

现代著名老中医 名著重刊丛书第十辑 (套装共7册)

伤寒大家

刘渡舟专著



人民卫生出版社

总目录

[伤寒论通俗讲话](#)

[伤寒论十四讲](#)

[伤寒论论解](#)

[新编伤寒论类方](#)

[金匱要略论解](#)

[经方临证指南](#)

[肝病证治概要](#)



现代著名老中医名著重刊丛书

刘渡舟医书七种



伤寒论

通俗讲话

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编
■ 刘渡舟 编著

第十辑



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·第十辑
刘渡舟医书七种

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编



伤寒论 通俗讲话

编著 刘渡舟
整理 傅士垣

人民卫生出版社

版权页

图书在版编目（**CIP**）数据

伤寒论通俗讲话 / 刘渡舟编著. —北京：人民卫生出版社，2013

（现代著名老中医名著重刊丛书. 第10辑，刘渡舟医书七种）

ISBN 978-7-117-17352-0

I. ①伤... II. ①刘... III. ①《伤寒论》—研究 IV.
①R222.29

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第120938号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购
书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

现代著名老中医名著重刊丛书（第十辑）

刘渡舟医书七种

伤寒论通俗讲话

丛书主编：王庆国 刘燕华

编 著：刘渡舟

出版发行：人民卫生出版社有限公司
人民卫生电子音像出版社有限公司

地 址：北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编：100021

E - mail: ipmph@pmph.com

制作单位：人民卫生电子音像出版社有限公司

排 版：人民卫生电子音像出版社有限公司

制作时间：2019年4月

版本号：V1.0

格式：mobi

标准书号：ISBN 978-7-117-17352-0

策划编辑：李丽

责任编辑：李丽

打击盗版举报电话：**010-59787491** E-mail: **WQ@pmph.com**

注：本电子书不包含增值服务内容，如需阅览，可购买正版纸质图书。

刘渡舟医书七种编写委员会

主 编 王庆国 刘燕华

副主编 李宇航 梁永宣

编 委（以姓氏笔画为序）

于博睿 马小娜 马春雷 王 冬 王庆国

王国华 王利敏 王雪茜 刘 敏 刘丹彤

刘晓倩 刘晓辉 刘燕华 闫军堂 许仲宁

孙 燕 孙良明 孙晓东 李 欣 李成卫

李宇航 李丽娜 李晓莉 李鹏英 吴范武

张 欢 张 娜 张雪亮 陈 明 陈 萌

畅洪昇 周 刚 郑丰杰 房克英 屈会化

赵 妍 赵 琰 赵伟鹏 赵宇明 钟相根

贾春华 倪 磊 高 飞 郭书文 梁永宣

程发峰 傅延龄 鲁 艺 赛佳洋

学术秘书 闫军堂

出版说明

自20世纪60年代开始，我社先后组织出版了一些著名老中医经验整理著作，包括医案、医论、医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国现代中医学术的发展发挥了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显。这些著名老中医在我国近现代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。他们的著作多成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前。无论是亲自撰述，还是口传身授，或是由其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华。诸位名老中医不吝秘术，广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，今已很难见到，部分著作甚至已成为中医读者的收藏珍品。为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将部分具有较大影响力的名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》并分辑出版，以飨读者。

第一辑 收录13种名著

《中医临证备要》《施今墨临床经验集》

《蒲辅周医案》《蒲辅周医疗经验》

《岳美中论医集》《岳美中医案集》

《郭士魁临床经验选集——杂病证治》

《钱伯煊妇科医案》《朱小南妇科经验选》

《赵心波儿科临床经验选编》 《赵锡武医疗经验》
《朱仁康临床经验集——皮肤外科》
《张赞臣临床经验选编》

第二辑 收录**14**种名著

《中医入门》 《章太炎医论》
《冉雪峰医案》 《菊人医话》
《赵炳南临床经验集》 《刘奉五妇科经验》
《关幼波临床经验选》 《女科证治》
《从病例谈辨证论治》 《读古医书随笔》
《金寿山医论选集》 《刘寿山正骨经验》
《韦文贵眼科临床经验选》 《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑 收录**20**种名著

《内经类证》 《金子久专辑》
《清代名医医案精华》 《陈良夫专辑》
《清代名医医话精华》 《杨志一医论医案集》
《中医对几种急性传染病的辨证论治》
《赵绍琴临证400法》 《潘澄濂医论集》
《叶熙春专辑》 《范文甫专辑》
《临诊一得录》 《妇科知要》
《中医儿科临床浅解》 《伤寒挈要》
《金匱要略简释》 《金匱要略浅述》
《温病纵横》 《临证会要》
《针灸临床经验辑要》

第四辑 收录**6**种名著

《辨证论治研究七讲》《中医学基本理论通俗讲话》
《黄帝内经素问运气七篇讲解》《温病条辨讲解》
《医学三字经浅说》《医学承启集》

第五辑 收录**19**种名著

《现代医案选》《泊庐医案》
《上海名医医案选粹》《治验回忆录》
《内科纲要》《六因条辨》
《马培之外科医案》《中医外科证治经验》
《金厚如儿科临床经验集》《小儿诊法要义》
《妇科心得》《妇科经验良方》
《沈绍九医话》《著园医话》
《医学特见记》《验方类编》
《应用验方》《中国针灸学》
《金针秘传》

第六辑 收录**11**种名著

《温病浅谈》《杂病原旨》
《孟河马培之医案论精要》《东垣学说论文集》
《中医临床常用对药配伍》《潜厂医话》
《中医膏方经验选》《医中百误歌浅说》
《中药炮制品古今演变评述》《赵文魁医案选》
《诸病源候论养生方导引法研究》

第七辑 收录**15**种名著

《伤寒论今释》《伤寒论类方汇参》
《金匱要略今释》《杂病论方证捷咏》
《金匱篇解》《中医实践经验录》
《罗元愷论医集》《中药的配伍运用》
《中药临床生用与制用》《针灸歌赋选解》
《清代宫廷医话》《清宫代茶饮精华》
《常见病验方选编》《中医验方汇编第一辑》
《新编经验方》

第八辑 收录**11**种名著

《龚志贤临床经验集》《读书教学与临症》
《陆银华治伤经验》《常见眼病针刺疗法》
《经外奇穴纂要》《风火痰瘀论》
《现代针灸医案选》《小儿推拿学概要》
《正骨经验汇萃》《儿科针灸疗法》
《伤寒论针灸配穴选注》

第九辑 收录**11**种名著

《书种室歌诀二种》《女科方萃》
《干祖望医话》《名老中医带教录》
《班秀文妇科医论医案选》《疑难病证治》
《清宫外治医方精华》《清宫药引精华》
《祝谌予经验集》《疑难病证思辨录》

《细辛与临床》（附 疑难重奇案七十三例）

第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）

《伤寒论十四讲》《伤寒论通俗讲话》

《伤寒论诠解》《新编伤寒论类方》

《经方临证指南》《金匮要略诠解》

《肝病证治概要》

这些名著大多于20世纪60年代前后至90年代后在我社出版，自发行以来一直受到广大读者的欢迎，其中多数品种的发行量达到数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床诊疗水平和促进中医事业发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时尽可能保持原书原貌，只对原著中有欠允当之处及疏漏等进行必要的修改。为不影响原书内容的准确性，避免因换算等造成的人为错误，对部分以往的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的临床检测项目与方法等，均未改动，保留了原貌。对于原著中犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社
2013年3月

整理说明

刘渡舟是北京中医药大学已故终身教授、《伤寒论》专业首批博士生导师，当代著名的中医学大家、中医教育家。刘老行医、执教半个多世纪，上溯岐黄之道，下逮诸家之说，力倡仲景之学，博采众长，学验宏富，形成了鲜明的学术思想和医疗风格，被誉为“伤寒泰斗”、“经方大家”，日本汉方界更称其为“中国治伤寒第一人”，其学术成就为中医同仁所公认，在中医学界享有盛誉。刘老以振兴中医、培育桃李为己任，在繁忙的医疗、教学、科研之余，坚持著书立说，笔耕不辍，培养后学。刘老一生著述颇丰，曾出版中医学术著作20多部，发表学术论文100余篇，为传承中医药事业作出了杰出贡献。

20世纪80年代，刘老的学术经验日臻成熟与完善，在当时十多年的时间里，他出版了数十部关于《伤寒论》、《金匱要略》及经方运用的研究专著，具有很高的学术水平和临床应用价值，深受广大读者欢迎，在中医学界产生了很大的影响，对于推动仲景学术发展和提高中医临床水平起到了重要的作用。为了系统总结刘老的学术思想和医疗经验，并从中窥探其治学方法与道路，我们精选了最能反映刘老治伤寒、用经方、精临证的学术著作，经撰次整理，辑而成帙，名为《刘渡舟医书七种》，付梓再版，以飨读者。这7本代表性医书分别是《伤寒论十四讲》、《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论诠解》、《新编伤寒论类方》、《经方临证指南》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》。这些著作能突出反映刘老之方证相对论、辨证知机论、古今接轨论、气机论、攻邪论、水火论、湿证论、脾胃论、肝胆论以及抓主证等学术思想及其对经方的运用经验，汇集了刘老行医50余年的学术经验和心血结晶，贯彻了理论和实践相结合的方针。通过阅读刘老文稿，读者可窥其学术思想和临床经验之一斑，并有助于系统地掌握刘老的临证特色和诊治经验。编撰者也希望通过这些文字笔墨展示经方大家刘渡舟教授的学术经历及成就，使一代名家为中医药事业不屈不挠的奋斗精神、人格品质及宝贵经验得以传世后人，为中国医学史树起一座不朽的丰碑。

为了使读者能原汁原味地阅读刘老著作，本次修订再版《刘渡舟医

书七种》时，采取尽可能保持原书原貌的原则，除对原著中出现的文字、标点错误稍加更正，并在不影响文意的前提下润色语句不通顺之处外，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排，从而规范了原书的体例层次。而对原书中出现的古今字、异体字、繁简字以及以往的病名、药名、计量单位等，均未改动，保留了原貌。

2007年，为了整理、挖掘、继承和抢救京城名老中医的学术经验，北京市中医管理局启动了“名老中医药专家学术思想抢救挖掘与优秀传承人才培养联动工程”（简称“薪火传承3+3工程”），目的在于做好首都名老中医学术思想的抢救、整理和挖掘工作。刘渡舟名家研究室

（No.2007-SZ-A-09）于2007年10月首批获北京市中医管理局批准，2008年1月授牌，2008年6月正式启动建设，进行了大量卓有成效的工作。将刘老积累多年的学术著作、文章、讲稿等整理、汇编、出版更是研究室的重要工作之一，本书即是在研究室全体成员的共同努力之下完成的，在此，谨向名家研究室这一名老中医学术经验平台的发起者——北京市中医管理局致以崇高的敬意。同时，也向所有参与此次编撰工作的各位同仁致以谢意。

刘渡舟名家研究室主任
北京中医药大学副校长，教授、博士生导师
王庆国
2012年12月

目录

[版权页](#)

[刘渡舟医书七种编写委员会](#)

[出版说明](#)

[第一辑 收录13种名著](#)

[第二辑 收录14种名著](#)

[第三辑 收录20种名著](#)

[第四辑 收录6种名著](#)

[第五辑 收录19种名著](#)

[第六辑 收录11种名著](#)

[第七辑 收录15种名著](#)

[第八辑 收录11种名著](#)

[第九辑 收录11种名著](#)

[第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）](#)

[整理说明](#)

[一、概论](#)

[（一）《伤寒论》的产生与演变](#)

[（二）《伤寒论》是一部什么书](#)

[（三）什么是“六经”](#)

[1.六经与脏腑经络的关系](#)

[2.六经与六气的关系](#)

[（四）六经病的传变](#)

[（五）六经病的主证、兼证、变证与挟杂证](#)

[（六）《伤寒论》的治法与方剂](#)

[（七）《伤寒论》的辨证论治精神](#)

[（八）怎样学习《伤寒论》](#)

[1.首先要熟读原文，在熟悉原文的基础上重点掌握方证](#)

[2.要学好《伤寒论》，还必须有较好的古汉语基础](#)

[3.熟悉并掌握中医药基本理论，是学好《伤寒论》的一个重要前提](#)

[4.与临床实践相结合，是学习《伤寒论》的最基本方法，也是学好《伤寒论》的关键所在](#)

[5.最后要指出的是，学习《伤寒论》一定要注意上下、前后条文之间的联系](#)

[二、辨病发阴伤寒热纲要](#)

三、辨太阳病脉证并治

（一）太阳病辨证纲要

（二）太阳病经证

1.太阳中风证治

2.太阳伤寒证治

3.辨麻桂越婢合方的小汗证

（三）辨不可发汗证

（四）辨传经与不传经

（五）辨太阳腑证并治

1.太阳蓄水证治

2.太阳蓄血证治

（六）虚烦证治与治疗禁忌

1.栀子豉汤证

2.栀子豉汤加减证

3.栀子豉汤禁忌证

（七）结胸证治

1.大陷胸丸证

2.大陷胸汤证

3.小陷胸汤证

4.三物白散证

5.陷胸汤的禁忌与结胸证预后

（八）心下痞证治

1.半夏泻心汤证

2.生姜泻心汤证

3.甘草泻心汤证

4.大黄黄连泻心汤证

5.附子泻心汤证

6.旋覆代赭汤证

（九）辨太阳病变证治法

1.表里先后、标本缓急与调整阴阳的治疗法则

2.邪热迫肺作喘证治

3.协热下利证治

4.误治变虚证治

5.火逆的变证

（十）太阳病类证与治疗

1.温病

2.风温

3.风寒湿痹证

四、辨阳明病脉证并治

（一）阳明病辨证纲要

（二）阳明病成因

（三）辨阳明病腑证并治

1.调胃承气汤证

2.小承气汤证

3.大承气汤证

4.麻子仁丸证

5.蜜煎导法

（四）辨阳明病可下与不可下

（五）辨阳明病经证并治

（六）辨阳明病热证并治

（七）辨阳明病寒证并治

（八）辨阳明病蓄血证并治

（九）湿热发黄证治

（十）阳明病的预后

五、辨少阳病脉证并治

（一）少阳病辨证纲要

（二）少阳病的正治法

（三）少阳病治疗禁忌

（四）少阳病机进退

（五）少阳病权变治法

1.柴胡桂枝汤证

2.大柴胡汤证

3.柴胡加芒硝汤证

4.柴胡桂枝干姜汤证

5.柴胡加龙骨牡蛎汤证

（六）热入血室证治

六、合病、并病

（一）太阳阳明合病

（二）太阳少阳合病

（三）阳明少阳合病

（四）三阳合病

（五）太阳阳明并病

（六）太阳少阳并病

（七）少阳阳明并病

七、辨太阴病脉证并治

（一）太阴病辨证纲要

（二）太阴脏病证治

（三）太阴经病证治

（四）太阴经脏俱病证治

八、辨少阴病脉证并治

（一）少阴病辨证纲要

（二）少阴病寒证

1.麻黄附子细辛汤证与麻黄附子甘草汤证

2.附子汤证

3.真武汤证

4.四逆汤证

5.通脉四逆汤证

6.白通汤与白通加猪胆汁汤证

7.吴茱萸汤证

8.桃花汤证

（三）少阴病热证

1.黄连阿胶汤证

2.猪苓汤证

3.少阴邪热外转太阳证

4.四逆散证

（四）少阴咽痛证治

（五）少阴病急下证

（六）少阴病治疗禁忌

（七）少阴病的预后

九、辨厥阴病脉证并治

（一）厥阴病辨证纲要

（二）厥阴病寒热错杂证治

1.乌梅丸证

2.干姜黄芩黄连人参汤证

3.麻黄升麻汤证

（三）厥阴病寒证

1.吴茱萸汤证

2.当归四逆汤证

（四）厥阴病热证

（五）厥阴病的病机进退

（六）厥阴病治疗禁忌

[\(七\) 厥阴病预后](#)
[十、辨霍乱病脉证并治](#)
[\(一\) 霍乱病辨证纲要](#)
[\(二\) 霍乱与伤寒的鉴别](#)
[\(三\) 霍乱病的证治](#)
[1.霍乱表里寒热证治](#)
[2.霍乱吐利亡阳证治](#)
[3.霍乱吐利阴阳两虚证治](#)
[4.霍乱吐利阳亡阴竭证治](#)
[5.霍乱病后的调治](#)
[十一、辨阴阳易差后劳复病脉证并治](#)
[\(一\) 阴阳易证治](#)
[\(二\) 差后劳复证治](#)
[\(三\) 差后复发热证治](#)
[\(四\) 差后腰以下有水气证治](#)
[\(五\) 差后喜唾证治](#)
[\(六\) 差后虚羸少气欲吐证治](#)
[\(七\) 差后日暮微烦证治](#)
[返回总目录](#)

一、概论

（一）《伤寒论》的产生与演变

《伤寒论》原书叫《伤寒杂病论》（或叫《伤寒卒病论》），为东汉张机所著。

张机，字仲景，南郡涅阳（今河南南阳）人，生活于公元150—219年。他曾跟随同郡张伯祖学医，经过多年的刻苦钻研，无论是医学理论，还是临床实践经验都胜过了他的老师，可谓是“青出于蓝而胜于蓝”。

张仲景生活于东汉末年，当时由于封建统治阶级的残酷剥削与压迫，特别是战争连年不断，以致民不聊生，疾疫广泛流行。张仲景的家本是一个大家族，有两百多人，但从建安元年以来，在不到十年的时间里，就死掉了三分之二，其中病死于伤寒的竟占十分之七。这种严重的疫情，特别是伤寒病对人民生命健康的严重危害，张仲景深深感到广大人民的横天莫救，决心认真总结前人的医疗经验，著书立说以治病救人。自秦汉以来，在总结大量临床实践经验的基础上，医学理论已逐步形成并不断完善；在应用单味药的经验不断丰富的基础上，逐步过渡到复方配伍，并开始产生复方配伍的理论，医学上的这些成就，为张氏著书创造了很好的条件，奠定了必要的基础。

《伤寒杂病论》问世不久，由于兵火战乱的洗劫，原书已散失不全。后经西晋太医令王叔和搜集整理，此书才又得以保存下来，但书中内容已有所调整与增减。到了宋代治平年间，高保衡、孙奇、林亿等人奉朝廷之命校订医书时，考虑到“百病之急，无急于伤寒”，因此先校订《伤寒论》10卷，颁行于世；其后又校订了《金匱玉函要略方论》（现简称《金匱要略》）。从此，《伤寒杂病论》一书就分为《伤寒论》与《金匱要略》两部书了。

现通行的《伤寒论》版本有两种：一是宋代治平年间经高保衡等人校过的刻本；一是南宋绍兴十四年（公元1144年，即金代皇统四年）成

无己的注本，叫《注解伤寒论》。除以上两种版本外，还有一个《伤寒论》的别本，叫《金匱玉函经》，共8卷，亦是由高保衡、孙奇、林亿等人校刻的，因与《伤寒论》同体而别名。现在，宋朝校订的原刻本已不可得，而仅存的是明代赵开美的复刻本，由于它还原了宋代治平本的原貌，故常被后来的医家所采用。成注本以明代嘉靖年间汪济川的校刊本为最好。

《伤寒论》全书共分10卷，22篇。本书只选取其中的《辨太阳病脉证并治法》、《辨阳明病脉证并治法》、《辨少阳病脉证并治法》、《辨太阴病脉证并治法》、《辨少阴病脉证并治法》、《辨厥阴病脉证并治法》等8篇，作为介绍的主要内容，其他如《辨脉法》、《平脉法》、《辨不可发汗脉证并治法》等诸篇，因多与上述8篇内容重复，故从略。

（二）《伤寒论》是一部什么书

对《伤寒论》的认识，历代注家有不同的见解，归纳起来不外两种：一种认为《伤寒论》是辨治外感热病的专书，具体地说，是辨治伤于风寒邪气所引起的外感疾病的专书；另一种则认为《伤寒论》是一部辨证论治的书，它把一些杂病也糅在外感伤寒之中，以六经分证来统摄诸病，是论病以辨明伤寒，非只论伤寒一病。它在六经分证的基础上，察寒热，定表里，分虚实，进一步判明病变的性质、部位、邪正盛衰以及疾病发生发展的规律，从而起到了提纲挈领、执简驭繁的作用。从这个意义上讲，《伤寒论》可以说是主论外感伤寒，兼论内伤杂病，其所见者大，所包者广，它的实用价值不能低估。

为了说明本书所论述的内容，先介绍一下什么是伤寒？伤寒有广义和狭义之分。《素问·热论》说：“今夫热病者，皆伤寒之类也。”是指广义的伤寒，即一切外感热病的统称；而狭义的伤寒，则专指感受风寒邪气所引起的外感病证。按《难经》所说：“伤寒有五，有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病”。《伤寒论》既然以伤寒命名，而且又分别论述了伤寒、中风、温病等多种外感病证，因此，可以说本书所论的伤寒是属于广义的伤寒。但从《伤寒论》中所涉及的主要内容来看，其重点仍在于论述狭义伤寒，因为有关温病的论述只是作为类证提出，以与伤寒作简明的鉴别和比较，并未作系统、全面的论述。

还需要指出，《伤寒论》所说的伤寒病也不同于西医所说的“伤

寒”。从病变过程及临床表现来看，西医所说的斑疹伤寒或伤寒、副伤寒，多属于外感温热病一类，与中医所说的伤寒病有别，不能混为一谈。

什么是杂病？汉代以前，凡属于伤寒之外的疾病，可概称为“杂病”。从《伤寒杂病论》中杂病部分的内容体会，当时所说的杂病，实际上相当于今之内科疾病，甚至比今之内科疾病的范围还要广。后来，虽然《伤寒杂病论》分为《伤寒论》与《金匱要略》两部书，但在辨证论治的具体内容上，仍是互相联系，互相渗透，难以截然分开的。况且《伤寒论》的六经分证，原为众病而设，并不是专为伤寒一病所用，它的辨证论治体系可以说是在临床上具有普遍指导意义的。所以，张仲景在“原序”中说：“虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源，若能寻余所集，思过半矣。”

（三）什么是“六经”

《伤寒论》是以六经作为辨证论治的纲领。六经就是太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴的统称。《伤寒论》的六经分证，继承了《素问·热论》的六经分证方法，并在此基础上吸收了汉以前有关平脉辨证与治疗的实践经验，使之更加系统与完善，更具有科学性和实践性。

《素问·热论》的六经只是作为分证的纲领，没有提出具体的辨证论治方法；从内容上看，也仅仅是论述了六经的热证和实证，未能论及六经的寒证和虚证。《伤寒论》的六经，能有机地将它所联系的脏腑经络的病变与证候加以概括，并着重用分析的方法指导辨证与治疗。具体地说，也就是根据人体抗病力的强弱、病势的进退、缓急等各方面的因素，对疾病发生发展过程中的各种证候，进行分析、归纳、综合，借以判断病变部位、寒热性质、正邪盛衰以及治疗的顺逆宜忌等，作为诊病治疗的依据。如风寒初客于表，表现为恶寒、发热、头项强痛、脉浮等太阳经表不利，营卫失和的证候，便是太阳病；若邪气化热入里，表现为热而不寒、口渴、汗出，甚或腹满疼痛拒按、大便燥结不下等胃肠燥热实证，便是阳明病；若邪气虽已离表，但又未入于里，与正气交争在半表半里的胁下胆经部位，表现为往来寒热、胸胁苦满、神情默默而不欲饮食、心烦喜呕、口苦、咽干、目眩等证候，便是少阳病。以上三阳经病，表示外邪侵犯人体，邪气虽盛，但正气不衰，与邪气斗争有力，表现为功能亢奋；其病变部位在表、在外、在腑；其病变性质以热证、实证为主。若病入三阴，说明机体的功能衰减，抗邪无力，寒邪入里而

病于脏，表现为阳虚阴盛的虚寒证。其中，表现为脾阳虚，寒湿内困，见到吐利、腹满疼痛、喜温、喜按等证的，是为太阴病；表现为心肾阳虚，阴寒内盛，见手足厥冷、下利清谷、精神萎靡、昏沉欲睡、脉微细等证的，则属少阴病；厥阴病是六经病的终末阶段，其病证以肝肾阳衰而又有阳气来复的寒热错杂证为主，表现有消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食、呕吐、下利等证。

从以上所列举的六经病证可以看出，它既是对疾病所表现的六类证候的概括，又表示伤寒病变过程中的既不相同而又相互联系的六个阶段。同时也体现了六经分阴阳，阴阳又统摄表里、寒热、虚实的六经与八纲的内在联系。下面再简单介绍一下六经与脏腑经络的关系及六经与六气的关系。

1.六经与脏腑经络的关系

六经是人体手足十二经的统称。由于经脉分别络属于相关的脏腑，经脉与脏腑在生理病理上是相互联系、相互影响的。所以，六经病证就是脏腑经络病变的具体表现。张介宾说：“经脉者，脏腑之枝叶；脏腑者，经脉之根本，知十二经之道，则阴阳明，表里悉，气血分，虚实见……凡人之生，病之成，人之所以治，病之所以起，莫不由之。”就切实地指明了经络与脏腑的密切关系，以及通晓脏腑经络学说，对于掌握疾病的发生发展规律，判断病证的阴阳、表里、寒热、虚实，从而对进行有效的辨证论治有着极其重要的意义。

六经病证是脏腑经络病变的反映，如三阳经病，反映了六腑的病变；三阴经病，反映了五脏的病变；在经之邪不解，可随经入里，发为腑病或脏病，如太阳经证不解，可随经入里发为太阳腑证等等，都是对六经病证与脏腑经络关系的很好说明。又由于经脉的沟通联系，各个经脉、脏腑之间都具有相应的表里关系，而这些具有表里关系的脏腑经脉，在发生病变时的相互联系、相互影响的关系，也在六经病证中有所体现。如太阳为病，阳气抗邪于表，则出现太阳经表证；若太阳抗邪无力，而在里的少阴阳气又虚，则太阳之邪也可以内传少阴；当少阴阳气得到了恢复，有力量抗邪于外时，则病变又可由阴转阳而外传太阳。像这种具有表里关系的经脉、脏腑病证的相互联系与影响，不仅表现在太阳与少阴之间，而且也同样存在于其他六经病证之中。因此，可以从阴阳、表里、寒热、虚实等各种矛盾的运动中，去认识脏腑经络的病理变化，这就是《伤寒论》认识疾病的基本方法。从这个意义上说，六经辨

证也是脏腑辨证的一个重要组成部分。

2.六经与六气的关系

六经、六气之说，源于《内经》，用于注释《伤寒论》则以清代张隐庵为代表。他用六经的经气特点，即太阳之气为寒，阳明之气为燥，少阳之气为火，太阴之气为湿，少阴之气为热，厥阴之气为风，来说明六经为病，或寒或热、或燥或湿、从标从本不同的病证，是具有一定的指导意义的。因此，为了能深刻地理解《伤寒论》六经病证的性质、特点及其发病机制，也有必要熟悉六经六气的道理。

（四）六经病的传变

伤寒六经为病，不是静止不动的，而是经常处于传变的运动之中。一般地说，凡邪气内传，则病证由表传里、由阳入阴；而正气能拒邪外出，则病证由里出表、由阴转阳。无论病证由表传里、由阳入阴，还是由里出表、由阴转阳，都可以说是传变，所不同的是前者属邪盛病进，后者为邪衰病退，病势有轻重进退的不同。

六经病证是否传变，主要决定于人体正气的盛衰及正邪斗争的状况。正气充盛，抗邪有力，则邪气不能内传；而正气虚衰，抗邪无力，则常导致邪气内传；若邪气虽已内传，但正气在与邪气斗争中逐渐得到恢复，又具备了驱邪外出的能力，则又可使病情由阴转阳，当正胜邪却时，还可以“战汗”的形式外解。正邪力量的对比，也是相对的。六经传变不仅与正气盛衰有关，而且与邪气的盛衰也有密切关系。若感邪势盛，所向披靡，长驱直入，也必然向内传变；而邪气不甚，或在与正气斗争中变衰，则无内传之力，或虽已内传，亦可转为外出之机。由此可见，六经病证的传变是有条件的，主要取决于正邪盛衰状况。判断六经是否传变，不应以病日数计，而应以脉证的变化为依据，《伤寒论》中提出：“伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也”，“伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也”，都是很好的证明。

六经病证的发生发展，不仅有传经而来的，而且也有直中的。“直中”是指病邪不经太阳初期阶段或三阳阶段，直接进入阴经的一种病变

形式。如伤寒直中太阴，起病即见吐利、腹满而痛的太阴证候。直中以直中太阴、少阴为多见，直中厥阴的较少见。病邪所以能越过阳经而直中阴经为病，主要原因是正气内虚，抗邪无力。因此，凡属直中多较一般传经之邪严重。

六经可以单独为病，也就是一个经一个经的单独发病或传变，也可以两经或者三经合并为病。其中，两经或者三经同时发病，称为“合病”，如太阳阳明合病、太阳少阳合病、阳明少阳合病以及三阳合病等；若是一经病未愈，而另一经病又起，有先后次第之分的，称为“并病”，如太阳与少阳并病、太阳与阳明并病、少阳与阳明并病等。从病情来看，合病多属原发，其势急骤；并病多属续发，其势较缓。

（五）六经病的主证、兼证、变证与挟杂证

六经病证复杂多变。学习《伤寒论》不仅要牢牢掌握六经主证，同时还要注意六经的兼挟证和变证，这样才能有效地指导辨证治疗。以太阳病的中风证为例：发热、汗出、恶风、脉浮缓是主证，当用桂枝汤治疗；若更见项背强几几，则属太阳中风的兼证，应治以桂枝加葛根汤；若“服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者”，则是太阳中风的变证，此时不宜再用桂枝汤，应该用白虎加人参汤治疗。至于所见的各种挟杂证，多与病人脏腑的寒热虚实有关。如有伤寒二三日，由于患者中气不足，兼见心悸而烦，用小建中汤治疗的挟虚证；也有“大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛”，宿食不尽，用大承气汤治疗的挟实证。

从整个六经病证来讲，其主证可以看做是辨病之常，其兼证、变证及各种挟杂证均可看做是辨病之变。知常方可达变，熟悉各经主证的证候及治疗，对于指导各种变证、兼挟证的辨证论治有重要意义。同时，也应该看到《伤寒论》中提出的多种误治后的变证，以及患者身体素质与宿疾不同所反映出来的各种挟杂证，又大大地丰富并充实了六经辨证的内容，突出并加强了《伤寒论》辨证论治的思想，从而不难看出，《伤寒论》确实具有伤寒与杂病合论的这一特点。

（六）《伤寒论》的治法与方剂

《伤寒论》的六经病证是复杂多变的，而与之相适应的治疗方法也是多种多样的，诸如麻桂的汗法、瓜蒂的吐法、硝黄的下法、芩连的清法、姜附的温法、参草的补法、柴芩的和法、虻蛭的消法，等等，可以说是集汗、吐、下、温、清、补、和、消八法之大成。《伤寒论》中载方113首，用药91味，组方严谨，用药少而精，方以法立，法以方传，字字有规矩准绳，用之也得心应手。

有关方剂的记载，在现存的古医籍中最早见于《内经》，它仅载13方，远不能满足临床治疗的需要。到了汉代，由于药物的不断丰富和发展，特别是复方的广泛应用，使方剂学在配伍理论、临床实践方面，均有较大的进展。近几年出土的汉代医药木简，为我们提供了这方面可靠的文物根据。从1972年12月在甘肃武威出土的一批东汉早期的医药简牘来看，内有医方30多个，而且几乎全是复方，用药约100种，可见当时的方药已有相当水平。虽然《伤寒论》中所载的方和药，并不全是张仲景所独创，但张仲景在继承并发扬汉代以前的医药学遗产，将理、法、方、药一脉贯通，开创辨证论治的治疗原则方面，做出了重大贡献。

《伤寒论》中的许多方剂，如桂枝汤、柴胡汤、白虎汤、承气汤、理中汤、四逆汤、乌梅丸、泻心汤等，经过了1700余年的实践考验，证明确实实用之有效。

（七）《伤寒论》的辨证论治精神

《伤寒论》在古典医籍中，以辨证论治著称，辨证论治精神贯穿于全书的始终。

辨证的方法，并不是从《伤寒杂病论》开始，张仲景在《伤寒杂病论》序文中提到“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》，并《平脉辨证》，为《伤寒杂病论》”，这里的《平脉辨证》是一部医书，已失传。日本山田正珍氏说：“《平脉辨证》诸书，今皆不传”。说明汉代以前就有了辨证的学说，并为伤寒六经辨证奠定了基础。其实，作为中医学术基本特点的辨证论治精神，早在《内经》就有所体现。特别是我国古代朴素的辩证法思想阴阳学说，影响并引进医学领域之后，开阔了医家辨认疾病的眼界，并以此奠定了辨证的思想基础。《素问·阴阳应象大论》强调“善诊者，察色按脉，先别阴阳”；后世的八纲辨证，以阴阳为辨证的总纲，其原因也就在此。看病时能运用阴阳的辨证思想，就能“知丑知善，知病知不病，知高知

下，知坐知起，知行知止，用之有纪，诊道乃具”，否则，就“知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知后，故治不久”。阴阳学说渗透到了中医学学术领域的各个方面，它不仅用以说明人体的生理功能、病理变化，而且也用以指导临床的诊断和治疗。

张仲景继承了阴阳学说，并结合临床实践，使之又有了新的发展。

《伤寒论》的六经辨证，就是以阴阳为纲，即用三阳、三阴的阴阳两纲总统于六经。进行六经辨证，应首先解决病发于阴，还是病发于阳，辨明阴阳，则是治病求于本。然后，进一步探求病位之所在、病情之所属、病势之进退，而判明表里、寒热、虚实，将八纲辨证贯穿于六经辨证之中。

六经辨证，通过八纲认识到疾病的阴阳、表里、寒热、虚实八个主要方面，可以说是辨证中不可缺少的先决条件。但是，如果只辨到八纲为止，那还是不够的，因为它还没有具体地把人体的脏腑经络的病理变化结合起来，就好像找人只找到了街道，还没有找到住户一样，仍然不能确切而深刻地阐明各种复杂的病理变化，并指导临证治疗。而六经辨证就恰好解决了这个问题，它把八纲落实到脏腑经络上，使八纲辨证和脏腑辨证有机地结合起来，从而补充了八纲辨证的不足之处。

由于六经辨证贯穿着八纲而联系于脏腑经络，尤其是以脏腑经络生理、病理变化作为物质基础，从而使辨证言之有物，而不是空中楼阁。前人在研究《伤寒论》六经时曾指出：“经者径也”，据经则知邪的来去之路；“经者界也”，据经则知病有范围，彼此不相混淆。有了范围，有了界线，就能使我们在辨证时一目了然，见头项强痛，可知是太阳经脉受邪；见缘缘面赤、额痛、鼻干，可知是阳明经脉受邪；见耳聋、胸胁苦满，可知是少阳经脉受邪；见腹满时痛，可知是太阴经脉受邪；见咽痛，可知是少阴经脉受邪；见巅顶痛、干呕吐涎沫，可知是厥阴经脉受邪。若离开经络学说，上述各个证候的发生与机制，就无法解释。又由于经络系统的联络交会，使人体的五脏六腑、表里上下、四肢九窍、皮肉筋脉等各个组织器官联结成为一个有机的统一整体，因此六经辨证也要特别注意脏腑经络病变的相互影响。如发热、恶寒而脉浮者，是属太阳经表受邪；若脉不浮而反见沉象，则知太阳表邪而又内累少阴。太阳与少阴为表里，当少阴阳气不足而外感风寒时，可以两经同时受邪，形成太阳与少阴的“两感”证。脾与胃互为表里，在发生病变时亦相互影响，故有“实则阳明，虚则太阴”的说法。这种病变的相互影响，表现在具有表里关系的经络脏腑之间，所以，辨证不能离开经络。宋代朱肱认为：“治伤寒先须识经络，不识经络，触途冥行，不知邪气之所在”。

辨证掌握了六经，就有了范围，有了规矩准绳，它是《伤寒论》的

核心。在这个基础上，张仲景又举出多种变证的辨证，用以羽翼六经辨证的不及。变证，是指误治后，证情发生了变化，甚至是治坏了的病证。它可以不受六经的限制和传经的约束，完全根据作者的想法和意图，具有很大的灵活性和机动性。正由于有内容丰富多彩的变证，穿插在六经辨证之中，因而大大地扩展了《伤寒论》的辨证范围。《伤寒论》中大约有近三分之一的篇幅论述误治的变证，这些变证所涉及的内容也是极为广泛的，如书中提到由于汗不得法引起的变证，就有“发汗后恶寒者，虚故也；不恶寒但热者，实也”，还有“发汗后，腹胀满者”，“发汗后……汗出而喘，无大热者”，“发汗后，其人脐下悸者”，“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按者”等等，可以说寒热虚实各个方面，无所不包，面面俱到，显示了辨证的多样性和复杂性。

《伤寒论》的辨证论治精神，还突出地表现在把许多相互关联又互相矛盾的证候及治法贯穿在一起，反复比较、鉴别，从中得出正确的结论，把人们的辨证思维引向深化。如书中提到的“伤寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之”；“太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也”；“自利不渴者，属太阴”；“自利而渴者，属少阴也”，都是通过一两个主要证候的鉴别、比较，使辨证分明。又如太阳病有麻桂的可汗法，又对“尺中迟者”、“尺中脉微”，以及“咽喉干燥者”、“淋家”、“疮家”、“衄家”、“亡血家”、“病人有寒”等不同情况，提出“不可发汗”的禁忌。阳明病证虽以下法为主，但在强调攻下的同时，又列举了禁下之证；在可下与不可下之间，反复分析，反复推敲，以详辨其什么情况可攻，什么情况不可攻；什么时候是“屎未鞭”，什么时候又为“屎定鞭”；什么时候先用小承气汤，什么时候又必用大承气汤；什么情况下不可下而可导，又什么情况下不可攻而可润等等，真是辨证分析淋漓尽致，提出的治法丰富多彩，使人眼界大开，思路广阔。

综上所述，可以看出《伤寒论》的辨证论治是继承了《内经》的学术思想，把具有朴素辩证法思想的阴阳作为分经认证的纲领，以指导疾病的诊断和治疗；同时，创立了六经辨证的体系又兼论杂病，从而使其辨证内容更加丰富。辨证在于分析，深入细致的分析、鉴别与比较，正面和反面并举，一分为二的看问题，这是六经辨证的基本方法，也是做出正确诊断和治疗的必要前提。

（八）怎样学习《伤寒论》

学习任何一门科学，都要掌握良好的学习方法，有了好的学习方法，可以收到事半功倍的学习效果。对于怎样学好《伤寒论》，古今医学家介绍了许多宝贵的经验，尽管他们处在不同的社会历史环境，学习《伤寒论》的深度、广度与要求不同，倡导的学习方法也不尽一致，但在一些基本方面还是差不多的，下面作简要介绍。

1.首先要熟读原文，在熟悉原文的基础上重点掌握方证

学习《伤寒论》，主要是学习它的辨证论治规律与方法，而这些规律与方法，均贯穿于原文之中。虽然后人为了学习与研究的方便，将原文划分为若干单元，并从各个不同角度加以注释。但我们的学习不能强客弱主，一定要立足于原著。对《伤寒论》的原文（或者说条文）要熟读，重点条文要能够背诵，这不仅对全面系统地理解掌握《伤寒论》理论体系有重要意义，而且对指导临床辨证论治也有极大的方便。“熟能生巧”，书读熟了，就打下了良好的基础，在应用时才能得心应手。原文要熟读，但也不是平均对待，重点的条文更要读熟记牢。什么是重点？从指导临床辨证治疗的需要考虑，应该说凡是辨证治法方药完备的条文都是重点。一部《伤寒论》载方113首（其中禹余粮丸方阙），它代表着113个方证，有些方证多次出现在前后条文之中，如桂枝汤证、麻黄汤证、白虎汤证、承气汤证、小柴胡汤证、四逆汤证等，但它们不是简单的重复，而是辨证内容的充实与论治方法的扩展。因此，这些条文都应该在熟读的基础上记牢，最好是能够背诵下来。当然，还有些条文，如“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也……”“病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也”，以及辨各经病脉证的提纲等等，虽然未提出治法与方药，但由于其辨证精确，具有指导全局、提纲挈领的作用，故亦需要背诵记牢，熟读原文或背诵重点条文，最好选用白文本，即不加注释的《伤寒论》。

2.要学好《伤寒论》，还必须有较好的古汉语基础

《伤寒论》成书于1700多年前的东汉时期，它的写作无论在语言文字及语法习惯方面，均有其时代特点。比如《伤寒论》与其他许多古医书一样，均用繁体字，这与现在之简体字就有很大不同；再如汉代的一

些词句，如“暈”、“更衣”、“嘔”等证候概念与使用方法同现在用语也不大一样，或者已经搁置不用了。在写作方面，对《伤寒论》的几种重要笔法，如倒装句、省笔、插笔、互文见义、假宾定主等亦均应有所了解 and 熟悉。如果我们不了解这些特点，不懂得汉代语言文字及语法结构等方面的一些基本知识，要学好弄通《伤寒论》是难以办到的。为了掌握古汉语基础知识，为进一步学习《伤寒论》及其他古医籍创造条件，应该学好医古文这门课程。而在学习《伤寒论》的时候，为了掌握它的医理，也一定要注意研究它的文理。

3.熟悉并掌握中医药基本理论，是学好《伤寒论》的一个重要前提

《伤寒论》是讲辨证论治的，属于辨证医学的专著。但它的学术思想是有继承性的，它继承了汉以前的医学成就，并吸取了当代的医学成果，以阴阳五行、运气、脏腑经络、病因病机、诊法治则及方药学等基本理论知识作为它的理论基础。因此，要想学懂、学深《伤寒论》，就必须首先学习好现代编写的《中医学基础》以及《内经》、《难经》等古典医籍。同时，还要学习《神农本草经》。《神农本草经》成书在《伤寒论》之前，是我国现存最早的中药学著作，它所论述的有关药物性味功能的理论，与《伤寒论》的用药规律最为接近。故此，学习《神农本草经》对探讨《伤寒论》的用药与治疗，则有着十分重要的参考价值。特别值得一提的是，要学好《伤寒论》，还必须学习《金匱要略方论》。它与《伤寒论》原本为一书，均系张仲景所著，现在分为两书，但它们在学术思想、所论病证以及理法方药等各个方面，都是互相联系，互相发明，互相印证，互相补充的。如《伤寒论》在举出半夏泻心汤证时，由于只强调与柴胡证、结胸证的鉴别，故述证有些不太完备，但这一不足，在《金匱要略·嘔吐下利病脉证治篇》得到了补充与发挥。类似情况甚多，不一一列举。这说明参看并对照《金匱要略方论》来学习《伤寒论》，无疑是会大有帮助的。

4.与临床实践相结合，是学习《伤寒论》的最基本方法，也是学好《伤寒论》的关键所在

理论来源于实践，又必须接受实践的检验，实践是检验真理的唯一标准。《伤寒论》来自于实践，是我国汉代医疗实践的总结，不仅有很高的科学性，而且有很强的实践性。它自东汉问世以来，至今仍延续不衰，被人们誉为中医药科学宝库中的一颗耀眼夺目的明珠，吸引着千百万医家去学习、探讨，其原因就在于此。我们今天学习《伤寒论》，探讨它的辨证论治规律，绝不仅仅是为了获得理论上的充实，更重要的是为了让它指导临床实践，为人类解除疾病痛苦。多临床，早临床，是学习中医的一条好经验，是毋庸置疑的一条正确途径，学习《伤寒论》更需如此。《伤寒论》中包含的许多深奥理论和辨证论治的规律与方法，需要通过临床实践去验证，在验证中加深理解；对诸多伤寒注家长期争论不休的问题，需要通过临床实践，学以致用，才能把《伤寒论》辨证论治的知识与技能真正学到手，使这些宝贵遗产得到继承与发扬。从古到今，学习或研究《伤寒论》的学者甚多，而真正有所发明、有所作为者，是那些在临床上探索的人们。作为间接经验，他们的心得体会、医案医话等，都很值得我们学习借鉴。

5.最后要指出的是，学习《伤寒论》一定要注意上下、前后条文之间的联系

善于前后互参，对比分析，则是学习《伤寒论》的一个重要而且有效的方法。《伤寒论》以六经辨证为纲，贯穿着脏腑、经络以及阴阳、表里、寒热、虚实等辨证内容。在它的编写体例上，虽然以六经病分篇，但每一篇的内容，却又不限于讨论一经之内的病证。各个条文虽有相对独立性，但也不是各自孤立，互不相关的，而是互相联系、互相补充、互相发明的。在学习的时候，只有把前后条文有机地联系起来，才能学得深透，领会得全面，从而把握住六经辨证论治的完整体系。比如太阳病篇，第1条举出太阳病辨证纲要，接着是太阳中风、太阳伤寒及太阳温病的辨证要点，然后分别论证太阳病的传变，太阳经证及腑证的辨证治疗与禁忌，太阳病误治或失治所引发的各种变证、坏证以及太阳病类证的辨证与救治。这一篇在六经病各篇中所占条文最多，所涉及的病证亦最广，六经病证几乎无所不包，而且还多有杂病内容。但该篇结构非常严谨，上下条文联系也非常紧密。六经病的其他各篇也均是如此。因此，我们学习《伤寒论》，一定要在一条一条学习的基础上，特别注意上下、前后条文之间的联系，着重各类病证之间的反复辨证与相互鉴别。有些伤寒注家为了学习与研究的方便，他们将《伤寒论》原条

文顺序打乱，进行重新归类编辑，如柯韵伯《伤寒来苏集》按方类证的方法，尤在泾《伤寒贯珠集》按法类证的方法，沈金鳌《伤寒论纲目》按症类证的方法，等等。现在的高等中医院校统编教材《伤寒论选读》，也是对原文进行了归类选编，它与上述几种类证方法不同之处在于突出了按病机分证的特点。它们的这些归类研究方法，不仅对揭示六经病证之间联系与差异很有帮助，而且对系统掌握并运用六经辨证论治规律与方法大有裨益。同时也告诉我们，学习《伤寒论》不仅要注意研究条文之间纵的联系，而且还要注意探讨各类方证之间横的联系。

二、辨病发阴阳寒热纲要

《伤寒论》的辨证方法，是以阴阳为纲统摄六经，进而辨清表里、寒热、虚实诸证。根据这一特点，把阴阳辨证大法，冠于六经辨证之前，是有其指导意义的。

凡邪气伤人，要了解病发部位，病变性质，只有通过辨证才能认识。要辨证则应先辨阴阳，才能抓住病的根本。张景岳在《类经·阴阳类》中说：“人之疾病……必有所本，或本于阴，或本于阳，病变虽多，其本则一”，这就说明疾病虽然千变万化，但其根本不外阴与阳两大类别。因此，掌握了辨别阴阳病证的规律，也可以说是掌握了辨证根本大法。

怎样辨别病证是属阴，还是属阳呢？《伤寒论》作了明确的回答：“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”。发热与恶寒是两个相互矛盾的证候，但这两个证候可以集中反映人体阳气的盛衰，抗邪能力的强弱。阳气有温煦机体，抗御外邪的作用。若阳气亢盛，能积极抵抗外邪，集于体表，就会有发热的表现；同时，由于阳气已被邪气所伤，处于不利状态，所以在发热的同时又有恶寒。恶寒，就是怕冷。病人发热与恶寒同时并见，说明感受外邪，阳气虽被邪气所伤，但并不衰弱，仍然有力与邪气抗争，使病拒于外而不得入于内，故谓“发于阳”；若只见恶寒，不见发热，说明机体阳气虚衰，无力与邪气抗争，病变已入于里，所以说是“发于阴”。

由于阴阳统摄六经而为八纲之总纲，因此，掌握阴阳的辨证规律，对指导六经辨证及表里、寒热、虚实的辨证有很大的现实意义。

一般地说，三阳经病均有发热，表示阳气有余，邪气亦盛，正邪斗争激烈，其病变属表（或属里）、属热、属实；三阴经多不发热而恶寒，说明阳气不足，抗邪无力，病变属里、属寒、属虚。

阴阳盛衰可验之于寒热，已如上述。但寒热又有真假之分，不可不辨。如患者身大热，好像是阳盛热证，但反而想多穿衣服或多盖被子，说明身热是假象，是由于阴寒盛于内，逼迫阳气浮于外所致，属于内有真寒、外有假热的阴盛格阳证，所以说是“热在皮肤，寒在骨髓也”。反

之，患者身大寒，或表现为怕冷，或表现为手足厥冷，但他不想多穿衣服或加盖被子以取暖，这说明身寒是假象，是由于阳热郁闭于内，格阴于外所致，属于内有真热、外有假寒的阳盛格阴证，所以说是“寒在皮肤，热在骨髓也”。

辨寒热真假，以患者身大热或身大寒，欲得近衣或不欲近衣，作为鉴别诊断的依据，是抓住了本质上的要害。但由于假象多见于重病患者，故在临证时，还应综合全面情况，方不至有误，如真寒假热证常伴见口不渴，或虽口渴但不欲饮水，尿清长，舌淡，脉大而软或数而无力等症；真热假寒常伴见口渴喜冷饮，尿黄赤，脉数，舌红等症。总之，只有慎重对待，全面分析，才能切实做到透过现象看本质，去伪存真。

三、辨太阳病脉证并治

太阳病，是外感病的初起阶段，由于这个时候正气开始抵抗，正邪斗争还只限于体表部位，故称为“表证”。

太阳病可分为太阳经证和太阳腑证两大类。由于证候表现不同，太阳经证又包括中风和伤寒两类；太阳腑证又包括蓄水 and 蓄血两类。除太阳的经腑证之外，还有邪热蕴郁胸膈不得伸发的虚烦证，热与痰或水互结的结胸证；若中焦寒热阻塞，升降失调，还可出现心下痞证；太阳病治不得法，也就是误治，还会发生种种变证；另外，还有一些类似太阳病的证候，作为太阳病类证应与太阳病鉴别比较。太阳与少阴为表里，若少阴阳气不足而感外邪，还可形成太阳与少阴同时俱病的“两感”证。

太阳病的治疗：经证属表，当用汗法；因感受风寒邪气，故宜以辛温解表之法。腑证蓄水，用通阳行水法；蓄血，用破血逐瘀法。若属太阳与少阴的“两感”证，当温经解表并用。至于其他诸证，或用温法，或用清法，或用补法，或用泻法，自当随证施治。

（一）太阳病辨证纲要

要掌握太阳病的辨证特点，首先应该弄明白什么是太阳，什么是太阳病。

太阳，指足太阳膀胱。太阳膀胱，其位居于下焦，内藏津液。肾阳蒸化膀胱津液，形成一种雾露之气，达于体表，叫做“太阳之气”。太阳之气，行于体表，具有温煦肌表，管理汗孔开合，防御外邪，保卫机体的作用，故又称为“卫气”。太阳之气也就是卫气运行于全身，古人认为卫气一日一夜行50周，昼夜各行25周，每日早晨当阴气尽时，则阳气出于目，目张则卫阳之气上行于头，然后循颈项而下行太阳经脉。由于太阳之气行于体表，在六经的最外层，又具有卫外的功能，所以就有“太阳主表，为六经之首，总统营卫，而为一身之外藩”的说法。《灵枢·营卫生会》说“太阳主外”，也是指它的部位及功能而言。

我们都知道肺是主表的，这里又提出太阳亦主表，它们有什么关系呢？

肺主表，是因为肺主宣发，能把卫气布散到体表，以行使温煦、卫外的功能。而太阳主表，则指太阳之气行于体表。太阳之气就是卫气，它出于下焦，由肾阳蒸化膀胱津液所产生，受胃的水谷之气而赡养，然后又通过上焦开发以“熏肤、充身、泽毛”。《灵枢·本脏》指出“肾合三焦膀胱，三焦膀胱者，腠理毫毛其应”，“肺合大肠，大肠者，皮其应”，就说明了脏腑相连，在内之脏腑与在外之皮毛相应的表里关系。皮毛属表，太阳之气行于表，是由少阴肾气所化，经肺气的宣发敷布外达皮毛，所以说肺气合于表而太阳之气则主表。

足太阳膀胱经是人体最大的一条经脉，循行路线最长，与督脉并行于人身的背部。背为阳之府，是人体阳气最集中的部位，太阳经从这里通过，所以说它是“阳经之长”。足太阳膀胱经行于内脏时，属于膀胱腑而络于肾脏。膀胱主藏津液，但它还要赖以肾气的作用使津液气化升降。以上介绍的可以说是太阳的生理。

由于太阳之气行于表，所以当外邪侵袭人体时，太阳必然首当其冲。太阳受邪，太阳之气抗邪于体表所表现的证候，就是太阳病。太阳主表，所以说太阳病就是表证。对于太阳病的主要脉证表现，《伤寒论》中作了概括：“脉浮，头项强痛而恶寒”，可作为辨太阳病的主要依据。

太阳病为什么见浮脉呢？因为邪气初客体表，太阳之气开始抵抗，气血趋向于外以抗邪，故脉应之而浮。“浮脉为阳表病居”，说明浮脉是表证的纲脉，凡见浮脉，当先考虑病在表。所谓“头项强痛”，是形容头痛项强，顾盼俯仰不能自如。《灵枢·本脏》说：“经脉者，所以行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节者也”。今太阳受邪，经气运行不利，故出现头项强痛的证候。头为诸阳之会，足太阳经上额、交巅、络脑、下项，所以太阳之为病必见头项强痛。太阳之气行于体表，行使其温煦卫外的功能，太阳受邪，温煦卫外的功能失常，故见恶寒。恶寒，是各种外感疾病的初起阶段，即表证阶段的必见证，它对判断病邪是在表还是已经入里，有重要的鉴别意义。“有一分恶寒，便有一分表证”，这个临床经验总结，就说明恶寒一证是判断病邪在表的一个重要标志。太阳为病，卫阳之气被郁，正气奋起与邪气斗争，还应见发热。而太阳病提纲中并未提发热，这是因为外邪入侵人体，卫阳被遏伤在先，故恶寒每先见于发热。《伤寒论》中说“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒”，就指出了太阳病发热可有迟早，但恶寒是必见的。太阳病是邪在表未入于里，故舌苔以薄白为多见。

以上脉证，是从太阳病脉证中抽出来的具有共性的证候，它反映了一切表证的最基本的证候特点，具有普遍的指导意义，所以把它们列为太阳病的辨证纲要。

（二）太阳病经证

太阳病，根据其证候特点，可以分为经证和腑证两大类。所谓太阳经证，是指病邪侵扰太阳经表而未聚结于太阳之腑所表现的证候。由于经与腑有表里之分，所以太阳经证就是太阳之表证；太阳腑证可以看做是太阳之里证。前面介绍的“脉浮、头项强痛而恶寒”的太阳病，主要是指太阳经证。

太阳病经证，按其所见脉证不同，习惯上又常分为太阳中风与太阳伤寒两种证候。

1. 太阳中风证治

太阳中风，是指风邪外袭，在太阳病“脉浮、头项强痛而恶寒”的脉证基础上，更见发热、汗出、恶风、脉缓等证的一种太阳表证，不同于“脑血管意外”的中风。因太阳中风用桂枝汤治疗，故太阳中风证又称为“桂枝汤证”。有关太阳中风的证治，下面就从桂枝汤主证、桂枝汤加减证和桂枝汤的禁忌证加以介绍、说明。

（1）桂枝汤主证

桂枝汤是治疗太阳中风的主方。要了解桂枝汤证，也就是要了解太阳中风证的病变特点，首先要从风邪的性质及其致病特点谈起。

风为阳邪，风阳袭卫，卫阳与风邪相搏，故见发热，发热证的出现既迅速又较突出。由于卫阳被风邪所伤，失去了卫护肌表、管理汗孔开合的作用，再加上风邪的疏泄，迫使营阴不能内守，因而自汗出。出汗越多，肌腠就越疏松不固，卫气也就更难抵御风邪的侵袭，故患者特别怕风。汗出肌疏，营阴外泄，反映在脉象上，就呈现了缓慢而有松弛虚弱感的一种缓脉。《伤寒论》中对太阳中风的脉证与病变机制，作了很形象的描述和很好的说明：脉“阳浮而阴弱”，即见浮取有余，重按不足

的浮而缓弱的脉象；“翕翕发热”、“淅淅恶风”、“啬啬恶寒”，形容像多着衣服那样的发热，像冷水淋在身上的怕风，而怕冷又表现出一种畏缩的样子。同时，由于风邪外袭，影响了肺气的宣发和胃气的下降，肺气不利则鼻鸣，胃气上逆则干呕。太阳中风的病理，《伤寒论》把它概括为“荣弱卫强”。“荣弱”是说营阴失去卫阳的固护而外泄，反映了正气不足的一面；“卫强”指风邪犯于卫分，反映了邪气盛实的一面。总体来看，风邪外袭以致营卫不和，就是太阳中风最基本的病变特点。

太阳中风证，既然是风邪外袭，营卫不和，治法就当解肌祛风，调和营卫，宜用桂枝汤。桂枝汤由桂枝、芍药、炙甘草、大枣、生姜组成。方中桂枝温通卫阳，配生姜之辛，以解卫分之风邪；芍药味酸能敛阴和营，配大枣之甘，可滋养营阴之弱；甘草和中扶虚。以上诸药内含辛、酸、甘味，由于辛甘化阳，可助卫；酸甘化阴，能以和营，故桂枝汤有调和营卫的功效。本方服法要求服药后喝热稀粥，其目的是使谷气内充，既可借以资汗源，又可强营卫以助抗邪之力。

太阳中风当用桂枝汤治疗，但桂枝汤却不仅限于治太阳中风证。如本属太阳伤寒证，经过汗下之后表邪仍不解；或虽经汗解，但又复感风寒病在表者，均应以桂枝汤再行解表。为什么此时要用桂枝汤呢？这是因为病原属伤寒，但已经汗下，尽管表证仍在，也不宜再用峻汗法，用桂枝汤可解肌发表，调和营卫，虽发汗以祛邪，但不损伤正气。正如《伤寒论》中所说：“伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤”。

还有一种情况，即有的患者内脏并没有什么毛病，只是不时的自汗，或伴以发热，这是什么原因呢？这是因为“卫气不和”，“卫气不共荣气谐和故尔”。也就是说，虽然患者营气和顺，但卫气不和，不能与营气密切协作，以致营卫各行其是，卫气不能外固，荣阴不能内守，因而“常自汗出”或“时发热自汗出而不愈”。这种既非太阳中风，又“脏无他病”的荣卫不和证，也要用桂枝汤，在未发病之前服药取汗，使营卫调和则愈。

曾治一患者李某，女，53岁。每日都有两三次发热、汗出，患病已一年。查其饮食、二便、睡眠皆佳。曾按阴虚治疗，服药廿余剂无效。诊其脉缓软，舌淡苔白，辨为营卫不和之证，遂用桂枝汤原方，只服二剂，则热止汗不出。

柯琴在评价桂枝汤时说：“此为仲景群方之魁，乃滋阴和阳，调和营卫，解肌发汗之总方也。凡头痛发热，恶风恶寒，其脉浮而弱，汗自出者，不拘何经，不论中风、伤寒、杂病，咸得用此发汗；若妄汗、妄

下，而表不解者，仍当用此解肌。如所云头痛、发热、恶寒、恶风、鼻鸣、干呕等病，但见一证即是，不必悉具，惟以脉弱自汗为主耳”。柯氏综合了《伤寒论》的有关条文，既概括指出了桂枝汤的应用范围，又告诉我们不可拘泥，要灵活运用；但灵活也不能失掉原则，要坚持辨证论治，要始终以客观脉证为施用方药的依据。下面举个病例以说明这个道理。

一男性患者，年六十，患荨麻疹，瘙痒钻心，数月不愈。其脉浮而弛缓，并见汗出而恶风寒，舌苔薄白，断为风邪稽留，营卫不和之证。用桂枝汤原方，不增减一味，嘱其喝热稀粥温覆取汗，一剂则疹退痒止。此例之所以用桂枝汤治荨麻疹取得疗效，其主要原因就是见到了桂枝汤的主要脉证，即汗出、恶风、脉浮缓，也就是遵循了辨证论治的法则。

太阳中风，当用桂枝汤。一般情况下，太阳中风患者服用桂枝汤，均可汗出而解。但也有“太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者”，这不是桂枝汤无用，是由于在经之邪太盛，服汤不能骤解，以致阳郁而增烦。遇到这种情况，应先针刺风池、风府二穴，以疏散在经之风邪，然后再服桂枝汤如法取汗，就能把病治好。

（2）桂枝汤加减证

对桂枝汤进行加减化裁，以治疗太阳中风的各种兼见证，就叫作桂枝汤的加减证。

【桂枝加厚朴杏仁汤证】

桂枝加厚朴杏仁汤，即桂枝汤加厚朴和杏仁。这个方在《伤寒论》中用以治疗太阳病中风又兼气喘的证候，即“喘家作桂枝汤，加厚朴杏子（即杏仁）佳”。

喘家，就是素有喘疾的人，又触冒风邪而病太阳中风。由于风邪外袭内迫于肺，以致肺气更为不利而作喘，应用桂枝汤以解肌祛风，加杏仁、厚朴宣肺降气以平喘。这是用桂枝加厚朴杏仁汤的一种情况。另外，还有两种情况，也用桂枝加厚朴杏仁汤治疗：

其一，患太阳病中风，并无气喘之宿疾，只因风邪外袭内迫，影响了肺气的宣发与肃降，故在汗出、恶风、脉浮缓、苔薄白等太阳中风的脉证基础上，更见胸满气喘。

其二，太阳病表不解，大便不通，本应先解表，然后再用下法。但

医生一开始就用了攻下的方法，以致表邪乘机内陷而迫肺，肺气不利，所以作喘。此时因表邪仍未解，故当以桂枝加厚朴杏仁汤，外解风邪，内利肺气。

许叔微在《伤寒九十论》中，举了一个桂枝加厚朴杏仁汤的治例，对后人运用此方有一定启示。他说，有一个武将被敌人俘虏后，关押在船舱里，数日才得以逃脱。跑出来后，这个武将饱饱吃了一顿，就坐在露天的地方，解开衣服歇息，不料第二日就得了伤寒。先请来一个医生，说是过饱伤食之证，而用下法；又请来一个医生，说是感受外邪，而用汗法。这样又下又汗，杂治几日不仅不见好，反而更增喘息，前医茫然不知所措，就又请来了许叔微诊治。许看了患者后说，这是太阳病用了下法，而表仍未解又见微喘，当用仲景的方法，以桂枝加厚朴杏仁汤治疗。前医见开此方，还有些疑惑不信。经服此药，一剂而喘定；再服，则汗出脉和身凉而病愈。

【桂枝加葛根汤证】

太阳病，本有头项强痛的太阳经输不利之证。若太阳中风，经输不利严重时，不仅颈项强急不舒而且连及背部，以致顾盼俯仰受限，这就是《伤寒论》中所说的“项背强**几几**”。**几几**，本是形容短翼之鸟伸颈欲飞而又不能飞的样子，在这里用以比喻项背强急而不舒。一般来讲，此证多见于伤寒无汗表实之证，而今却反见汗出、恶风，故知这个证候，仍属太阳中风的范围，还要用桂枝汤以解肌祛风，加葛根则可以疏通经脉以治项背强急。

原宋本《伤寒论》中记载，此方中尚有麻黄，但林亿等人又在方后注：既有汗，不当有麻黄。故后来的注家，多按照林亿等人的见解，去掉了麻黄。

【桂枝加附子汤证】

桂枝加附子汤证，是太阳中风又兼有表阳虚的证候，可见于太阳病发汗之后。

太阳病用发汗的方法治疗理所应当，但为什么病没有治好，反而伤了表阳呢？问题就在于汗不得法。按要求，太阳病发汗只宜发微汗，不可大汗令“如水流漓”。若发汗太过，不仅邪不去、表不解，反而使阳从汗泄，更伤卫阳。表不解，则仍见汗出、恶风；表阳虚，肌表不固，则汗漏不止；汗出过多，津气俱伤，筋脉失养，气化不利，所以“小便难，四肢微急难以屈伸”。此时，表不解又兼见亡阳脱液，故以桂枝汤

解肌发表，加附子以温经回阳，固表敛汗。

本证既有津伤，但方中并不加生津益阴的药物，其理何在？陆渊雷作了很好的说明：“津伤而阳不亡者，其津自能再生；阳亡而津不伤者，其津亦无后继。是以良工治病，不患津之伤，而患阳之亡……桂枝加附子汤之证，伤津而兼亡阳也，仲景则回其阳而已，不养其津，学者当深思之”。

有关桂枝加附子汤的用法，举一个例子说明。同事仆老师，在回乡探亲前向我求方，他说有一个亲戚患自汗证，身体虚惫不堪。曾用黄芪、党参、龙骨、酸枣仁、浮小麦等止汗固表药不效，问我怎么办？我告诉他，如无热象，可试用桂枝加附子汤。他回乡后用此方果然取效。后来，他对我说，阳虚出汗，非附子而不能止，若早看到这一点，病也不至于拖延至今哪！

【桂枝去芍药汤、桂枝去芍药加附子汤证】

太阳病应当用汗法，不能用攻下法，若误下则属逆其病机，可使在表之邪内陷。由于阳气开发于胸中，表又近于胸位，因此误下往往使表邪内陷胸中，影响阳气的开发以致胸满。此时，其脉若沉紧有力，恐为结胸之变；若脉来急促，按之而软，说明阳气虽因误下受挫，但仍能与邪气抗争，病在阳而未入阴，在胸而未入腹。正因邪气去表未远，故用桂枝去芍药汤以鼓舞心胸阳气，驱邪从表外出。

桂枝去芍药汤，方用桂枝、炙甘草以扶心胸之阳；配以生姜、大枣辛甘发散，使内陷胸间之邪从表解；因芍药酸寒，其性阴凝而敛，不利于胸阳的宣通畅达，故不用。

若在上证基础上更见微恶风寒，说明阳气损伤较重，显现出温煦失职之象，故须于上方中加附子，以扶阳气之虚损。

治验举例：王某，男，36岁。自诉胸中发满，甚或作痛，每逢严冬季节发作更甚。兼见咳嗽，气短。切其脉弦而缓，握其手冷如冰，问其小便则清而长。参合上述脉证，断为胸阳不振而有寒。因冬月阴寒最盛，阳受其困，故病情增剧。为之处方：附子9克，桂枝9克，生姜9克，大枣7枚。

患者见上方除姜枣外，仅二味药，有些不相信。一周后他高兴的告诉笔者，服上药后多年宿疾已愈。

【桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证】

太阳病未经发汗的身体疼痛，是表不解；已经发汗后的身体疼痛，

多为气血两虚，不能濡养筋脉所致。凡属表证的身疼，其脉应浮；属气血虚的身疼，脉多见沉迟而涩。气虚血少，充盈鼓动血脉的力量不足，故脉沉迟而涩滞不畅。表证身疼，治当汗解；汗后气血不足的身疼，则应温补，用桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤治疗。

桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤，是由桂枝汤加重芍药、生姜的用量，再加人参所组成。桂枝汤有调和营卫的作用；加重芍药以滋养营血；加人参补气生津，调营养卫；重用生姜可宣通阳气，使药力达于体表。

曾治一樊姓妇女，新产之后，忽而身痛，自服生化汤两帖无效。随笔者实习的学员诊为气血两虚身痛，用当归、黄芪、党参、白术、甘草等药，服之有效但治不彻底。切其脉沉缓无力，舌淡苔白，嘱用新加汤，三剂而病愈。学员不解，纷纷问询是什么道理？笔者对他们说，关键在于桂枝汤走肌表而参芪走里，身疼痛一证是在表的营卫气血不足，故进参芪其效则缓，而服桂枝汤就取得了满意的疗效。

【桂枝去桂加茯苓白术汤证】

病有类似太阳病，实非太阳病，临证时不能不加以辨别。如有一种病表现为头项强痛，翕翕发热而无汗，并有小便不利，心下胀满微痛。若辨头项强痛、翕翕发热为表不解，投以桂枝汤发汗；或认为心下满微痛是里邪凝结，用攻下法治疗均不见效，如《伤寒论》中所说：“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利”。此证汗之不解，下之不愈，究竟是什么病证呢？由于膀胱气化失司，水邪内停，故小便不利；水邪凝结，影响中气不运，所以心下胀满微痛。经脉与脏腑相通，腑病影响了在外之经气不和，故见头项强痛、翕翕发热等证，这是水遏阳郁不得宣畅的表现，属于太阳之邪内陷，以致膀胱气化失职的水饮内停之证。与太阳中风的翕翕发热、汗出、恶风之证截然不同，所以不能用桂枝汤，应该用桂枝去桂加茯苓白术汤治疗。

桂枝去桂加茯苓白术汤由芍药、炙甘草、生姜、大枣、茯苓、白术组成。因为表无邪，故不用桂枝；水饮内停，小便不利，故加茯苓、白术；方中用生姜，可健胃以散心下之饮；用芍药助疏泄以解心下之痛；甘草、大枣有培土制水的功效。因本方所治之证，属太阳之里影响于太阳之表，并无太阳表证存在，故不需汗出而解，只要“小便利则愈”。

陈慎吾老大夫，曾治一发热患者，屡经医治，发热不退。问其小便不利，而胃脘胀满不舒，脉沉而弦，舌苔白而水滑，辨为水饮内停，阳气外郁，乃不治热而治水，用桂枝去桂加茯苓白术汤，三剂热退而安。

对桂枝去桂加茯苓白术汤证，各医家也有不同的看法，《医宗金鉴》认为：“去桂当是去芍药。此方去桂，将何以治仍头项强痛、发热、无汗之表乎？……故用桂枝汤去芍药之酸收，避无汗心下之满，加苓、术之渗湿，使表里两解，则内外诸证自愈矣”。自《医宗金鉴》提出“去桂当是去芍”之说后，对这个问题就展开了争论，同意《医宗金鉴》观点者亦有不少人，故将此见解提出来，供参考。

以上列举了桂枝汤的加减诸证，虽不能面面俱到，但可举一反三，触类旁通。后世医家徐灵胎在此方基础上加黄芪、当归；叶天士则加杏仁、干姜、五味子等等，他们均能在辨证论治的原则指导下，做到随证加减，灵活变通，不断地扩大了桂枝汤的应用范围。

（3）桂枝汤禁忌证

桂枝汤是治疗太阳中风证的主方。太阳中风以发热、汗出、恶风、脉浮缓为主要临床表现和辨证依据。若病人见发热、恶寒、无汗、脉浮紧，说明所患之病是太阳伤寒，并非太阳中风，应当用麻黄汤不能用桂枝汤治疗。所以，《伤寒论》中提出：“桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也”。“解肌”指桂枝汤有解肌腠之邪的作用，是对麻黄汤解表作用相比较而言。由于太阳中风桂枝汤证与太阳伤寒麻黄汤证，在病因上有伤于风和感于寒的不同，在病理上有卫强营弱与营强卫闭的不同，在临床表现上又有汗出与无汗的区别，因此，这两种不同的病证就有完全不同的治法。若太阳中风错用麻黄汤发汗，可出现“汗漏不止……小便难，四肢微急，难以屈伸”的桂枝加附子汤证；若太阳伤寒误用桂枝汤，不仅由于药不对证而病不解，还可能由于桂枝汤中芍药的酸寒收敛，使表寒更加郁闭，变化为“不汗出而烦躁”的大青龙汤证或其他病证。对于上述一些问题，在临床上一定要认真对待，不可粗心大意，以免给患者带来不应有的痛苦。为此，张仲景也特别告诫我们：“常须识此，勿令误也”。

太阳伤寒证不能用桂枝汤，这是桂枝汤禁忌证之一。此外，《伤寒论》中提出“酒客病”不能用桂枝汤。酒客，指有喝酒嗜好的人。由于长期饮酒无以节制，故酒客的湿热较盛。湿热内蕴，熏蒸于外，致营卫不和，可出现汗出、干呕、头痛等类似太阳中风的证候，称为“酒客病”。治疗应该用葛花、枳椇子等解酒利湿药物，不能用桂枝汤。若误投桂枝汤，不仅酒客病不解，反而由于桂枝汤为辛甘温之剂，辛温能以助热，甘药能以助湿，酒客服后使湿热更盛，壅滞于中，影响胃气的和降，引起呕吐。张仲景在《伤寒论》中，把这个道理归结为：“以酒客不喜甘

故也”。

酒客病禁用桂枝汤是有一定道理的，但在具体应用时不可拘泥。当酒客太阳中风时，无湿热表现，可用桂枝汤；虽不是酒客，但这个人湿热素盛，当病太阳中风时，桂枝汤也当慎用。日本山田正珍提出用化裁桂枝汤治疗酒客患太阳中风证：“若夫平素好饮之客，虽有中风之证，不可执桂枝之成法与之，宜减去甘、枣二物以投之。”可供我们临证时参考。

太阳病，以发汗为治疗大法。若不发汗，反泻下，就是治疗上的错误。如虽经误下，但并未导致邪气内陷，太阳之气仍能抗邪于外，即“其气上冲者”，就还可以用桂枝汤发汗解表，这正如《伤寒论》中所说：“太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法”。若误下之后，太阳之气不上冲，表证已不在，邪气内陷于里，桂枝汤就不能用了。其实不仅误下，就是发汗不得法，或错误地用吐法、温针等方法，都会使病情发生变化，以致发生“坏病”。既然病证有变，治法方药当随之而变，此时再用桂枝汤就不中用了。如《伤寒论》中所说：“太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也”。发生了坏病，桂枝汤又不中用，该怎样救治呢？还是张仲景说的好：“观其脉证，知犯何逆，随证治之”，也就是要遵循辨证论治的法则。

2.太阳伤寒证治

太阳病伤寒，是指感受寒邪，在太阳病“脉浮、头项强痛而恶寒”的脉证基础上，更见无汗而喘、头疼、身疼、腰痛、骨节疼痛、脉紧等证的又一种类型的太阳表证。因其主治以麻黄汤，故太阳伤寒证又称“麻黄汤证”。太阳中风与太阳伤寒同属太阳病经证，但又是不同病变特点的两种证候。太阳中风，因其感受风邪，汗出肌疏，故又称“表虚”；太阳伤寒，因其被寒邪所伤，无汗表闭，故又称“表实”。

（1）麻黄汤主证

要了解麻黄汤主证，即太阳伤寒证的病变特点，就要先从寒邪的性质及致病特点说起。

寒邪，在六淫邪气中属于阴邪。它侵袭人体，最容易损伤人体的阳

气。阳气被寒邪所伤，失去正常的温煦作用，所以要恶寒。伤寒的恶寒是很厉害的，即使多穿衣、多盖被，或者烤火取暖，常不得缓解。寒主凝，主痛，主收引。外感寒邪，营卫凝涩不利，皮毛腠理敛缩闭塞，所以见无汗、身疼、腰痛、周身骨节疼痛。“肺之合皮也，其荣毛也”，皮毛汗孔被寒邪闭郁，肺气也就不得宣发，肺失宣降，则上逆作喘；若影响到胃气的和降，还可见呕逆。因感寒使脉道收缩而拘急，故脉“阴阳俱紧”，寸关尺部位出现浮紧的脉象。由于寒邪伤人，卫阳被遏在先，故太阳伤寒每先见恶寒，紧接着也要发热。《伤寒论》综合了太阳伤寒的各种见证，并提出治法：“太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。”这里提出的头痛发热等八个证候是太阳伤寒的主要证候，并以此与太阳中风桂枝汤证加以区别。

太阳中风与太阳伤寒均属太阳病，故脉浮、头项强痛而恶寒是它们的共见证。但中风表虚以汗出、恶风、脉浮缓为主；伤寒表实以无汗、恶寒、身疼、脉浮紧为主，两者有所不同。

太阳伤寒病变的关键在于卫气之闭，卫气闭之因，在于外寒之凝滞，故本证当用麻黄汤辛温散寒以解表。

麻黄汤由麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草组成。麻黄辛温，可发散风寒，开腠理而发汗，宣肺平喘；桂枝通阳解肌，助麻黄发散风寒；杏仁苦温利肺，助麻黄宣肺平喘；甘草调和诸药而和中。本方为辛温发汗之峻剂，炙甘草量宜小不宜大，以防有碍于发汗解表。

笔者于1967年随医疗队赴甘肃。当时正赶上隆冬季节，因冒受风寒而外感。周身关节无处不痛，恶寒特甚，体温39.8℃，无汗，咳嗽，脉浮紧。笔者自己开了一剂麻黄汤，服后躺在火炕上发汗，约一时许，通身汗出而病解。

一般地说，典型的太阳伤寒以麻黄汤发汗，用之得当，可以药到病除。如果治不及时，失于发汗，以致阳郁过甚，邪无出路，则可发生鼻衄。

为什么“伤寒，脉浮紧，不发汗，因致衄”呢？这是因为汗与血同源，外寒闭郁，当汗不汗，邪不能从汗解，势必造成阳郁更甚，以致迫血妄行，从衄而解，是正气抗邪于外的一种自然疗能，说明营分之邪有外出之路，起到了“衄以代汗”的作用。因此，麻黄汤证有“衄乃解”和“自衄者愈”的情况，人们习惯上把伤寒衄血称为“红汗”，是“出大寒”。但也有衄而不解的，多因衄而不畅，不能载邪外出，就好像汗出不彻，表邪不解一样。此时，还应再用麻黄汤发汗，以消营中之邪，使汗出邪越而血自宁，这种再以麻黄汤发汗的方法是“汗以代衄”。若衄后

病不解，更见身热夜甚，舌绛苔燥，心烦不寐，脉细数等证，说明邪已化热，内陷营血，应治以清热凉血之法，万万不可再用麻黄汤发汗。

麻黄汤本有衄血之禁（后文还要提到），这里却又说伤寒“不发汗，因致衄者，麻黄汤主之”，这不是有矛盾吗？其实不然，这里所说的因表邪不解而致衄，与麻黄汤禁忌证中的先衄后病伤寒有根本不同。彼属衄家，则禁汗；而此属失汗致衄，则可汗。正如江篁南所说：“久衄之家，亡血已多，故不可汗；今缘当汗不汗，热毒蕴结而成衄血，当分其津液乃愈。盖发其汗，则热越而出，血自止也”。

（2）麻黄汤加减证

在麻黄汤的基础上进行加减化裁，治疗太阳伤寒的各种兼挟证，就称为麻黄汤的加减证。其包括伤寒挟水饮咳喘的小青龙汤证，兼阳郁烦躁的大青龙汤证，以及兼太阳经输不利的项背强几几的葛根汤证。

【小青龙汤证】

小青龙汤证，是属于伤寒又兼挟水饮的一种病证，简单地说是属于外寒内饮证。《伤寒论》概括它的病变是“伤寒表不解，心下有水气”。

“伤寒表不解”，是说有恶寒、发热、无汗、身疼痛等太阳伤寒的表证存在；“心下有水气”，是指素有水饮内停犯胃，胃气不降则上逆作呕；外寒内饮，上射于肺，肺失宣降则咳喘。由于水邪变动不居，可随气机升降到处为患，故小青龙汤证的或见证特别多。如水饮走于肠道则下利；蓄于膀胱，气化失职，则小便不利、少腹满；水寒壅滞于上，阻碍气机则噎；水饮内停，气不化津，则口渴等。因属寒饮为病，所以脉弦、苔白而滑、咳吐清稀泡沫样痰，这几个脉证对本证的辨别有重要意义。治疗用小青龙汤，外解风寒，内散水饮。

小青龙汤，由麻黄、桂枝、芍药、细辛、干姜、半夏、炙甘草、五味子组成。方中用麻黄发散风寒，平喘利水；配桂枝，可增强通阳宣散的功能；干姜、细辛，可散寒化饮；半夏去痰降逆；甘草扶正和中；恐辛散太过，耗伤正气，故用五味子酸收，以保肺肾之气，助以芍药酸收微寒，敛荣阴而防动血，如此配伍，可使邪去而正不伤。方中干姜、细辛、五味子三药配合使用，以温散肺饮，止咳平喘，这也是张仲景治咳喘药物配伍的一个特点。

小青龙汤证有寒饮内扰，故一般情况下病人口不渴；若服小青龙汤后，病人口渴欲饮，这是“寒去欲解”的反映，也就是寒饮散去而胃阳得

以恢复的好现象。

本方在临床上并不仅限于治疗表寒内饮证，即使没有表证，但只要属于寒饮咳喘，就可使用。《金匱要略》就有用小青龙汤治疗“溢饮”，以及“咳逆倚息不得卧”等证的记载。若寒饮有化热趋势表现，有烦躁证者，可在本方中加生石膏。本方只要辨证恰当，临床用之多有效，但不宜久服。因它不仅能发散阳气，而且又能伤阴动血，故对某些心脏病引起的咳喘以及肺结核等病，应当慎用。

【大青龙汤证】

大青龙汤证，是由于伤寒失汗，表邪不解，阳郁化热形成的表寒兼内热的证候。

表寒不解，所以脉浮紧、发热恶寒、身疼痛的表实证俱在。当汗不汗，卫阳被表寒闭郁而化热，阳热内扰，故见烦躁。这里的表寒与内热，虽是两种不同的病理变化，但两者之间有着密切的内在联系。《伤寒论》中说“不汗出而烦躁”，就指出了烦躁是由于不得汗出，阳郁不宣所致。单是表寒不解，只用麻黄汤发汗就可以了。本证是外寒兼内热，故再用麻黄汤就不行了，应该用大青龙汤外解风寒，内清烦热。

大青龙汤，可以说是在麻黄汤的基础上化裁出来的。它是麻黄汤倍用麻黄的剂量，再加生姜、大枣、生石膏所组成。方中重用麻黄，助以桂枝、生姜发汗以解表；用杏仁利肺气，助麻黄以宣发；石膏辛甘大寒，配麻黄解肌以开阳气的郁闭，并能清热除烦；甘草、大枣能和中扶正，在发汗剂中还有资助汗源的作用。

大青龙汤属发汗峻剂，体质壮实的可用，体质虚弱的不可用，如病人脉微弱、汗出恶风，属中风表虚证的也不能用。若表虚证误服此方，可因发汗太多，以致发生四肢厥逆、肌肉跳动的亡阳之变。为防止汗多亡阳，张仲景特别在方后注：“汗出多者，温粉扑之。一服汗者，停后服”。“温粉”即米粉炒温，扑在身上，用以止汗。

有一位姓邱的医生，在笔者所在学院旁听《伤寒论》课，当讲到大青龙汤证时，他介绍了用这个方治愈了的一个病例：他家乡在抗旱打井时，一壮年社员，遍身汗出如洗，缒绳下井，井底寒气逼人，顿时汗消，随之即病。发热恶寒，一身疼痛而烦躁难耐。邱医生看了患者，认为是大青龙汤证。但考虑当时正是暑夏季节，又不敢贸然进药，后在别的医生鼓励与协助下，他给患者开了一付大青龙汤。只服一煎，患者遍身汗出，热退身凉而神安。

大青龙汤，用以治疗“不汗出而烦躁”的表寒内热证，这只是其适应

证的一个方面。还有一个方面，就是在不得汗的同时，不仅阳气被郁不得发越，而且行于肌表的水液也凝滞不流，由于阳郁而水滞，则脉由紧变缓，并可出现周身沉重或兼见疼痛；或四肢酸沉，难于抬举；或四肢关节肿痛等证，此时亦可用大青龙汤，以发泄其水邪，使从汗出而解。

《伤寒论》中所述：“伤寒，脉浮缓，身不疼但重”，以及用“大青龙汤发之”，就都是针对饮邪而言的。

（3）葛根汤证

太阳病经证，若由风邪所中，使太阳经脉不利，见“项背强^{几几}，反汗出恶风”等证候，属太阳表虚兼经输不利证，当用桂枝加葛根汤治疗；若被寒邪所伤，见“项背强^{几几}，无汗恶风”等证，属太阳表实兼经输不利证，应以葛根汤治疗。同为“太阳病，项背强^{几几}”，但有中于风、伤于寒的表虚、表实的不同，其鉴别要点在于有汗与无汗。

伤于寒邪，寒性凝滞收敛，故无汗；太阳经气不利，津液不能上输，筋脉失于濡养，故项背拘紧而不舒。葛根汤不仅能发汗解表以散寒，且能升津液以舒筋脉。

葛根汤，由葛根、麻黄、桂枝、生姜、炙甘草、芍药、大枣组成。方用葛根，既能解肌表之邪，又能升津液，濡养筋脉，以缓项背之拘紧；麻黄、桂枝、生姜辛温散寒，可发汗解表；芍药佐葛根，可利血脉以缓筋急；甘草、大枣和营卫而守中，也可制约麻、桂之辛散。

病案举例：封姓工人，病恶寒，遍身无汗，循脊背之筋疼痛不能转侧，脉浮紧。此外邪袭于皮表，故恶寒无汗。况脉浮紧，证属麻黄，而项背强痛，因邪气及于背输经络，宜治以葛根汤。葛根五钱、麻黄二钱、白芍二钱、甘草二钱、生姜四片、红枣四枚。

服药后顷刻，觉背内微热，再服背汗遂出，次及全身，安睡一宵，病遂愈。（《经方实验录》）

3.辨麻桂越婢合方的小汗证

太阳病经证，已介绍了属于中风表虚的桂枝汤证，属于伤寒表实的麻黄汤证。但还有一部分太阳经表证，或因迁延日久，或因已服发汗解表药物，大邪虽去而小邪仍在，此时既不能单用麻黄汤，也不能独用桂

枝汤，根据病情，张仲景在《伤寒论》中又另设桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤等三个小汗法，以补桂枝汤、麻黄汤等治疗的不足。

（1）桂枝麻黄各半汤证

太阳病表证不解，延迟八九日之久，当考虑有传经入里的可能。但判断是否已传经，则必须以客观脉证为依据。现病人不呕，说明未传入少阳；大便正常而不燥结，即“清便欲自可”，说明也没有内传入阳明；发热恶寒同时并见，说明病邪更没有内传三阴，仍在于表。邪在表，正气与之斗争，正有胜负，邪有进退，故时凉时热，寒热休作，像发疟疾一样一日发作二三次。如果寒热不等，表现为发热时间多怕冷时间少，即所谓“热多寒少”，切其脉不紧不数，呈微缓脉象，说明在正邪斗争过程中正胜邪却，是疾病自愈的征象，可不用治疗；若其人恶寒多发热少，脉微而不兼和缓之象，说明这个患者阴阳气血俱虚，正气衰不能胜邪，这种情况非但不可发汗，就是吐、下也在所禁忌；若其人脉不缓不微而见浮象，面色正赤带有发热的表现，说明有小邪在表留恋不解，以致阳郁不得宣泄，汗欲出而不得出，邪郁肌表不得发散，故皮肤必发痒，治疗宜以桂枝麻黄各半汤发点小汗。

桂枝麻黄各半汤，是桂枝汤与麻黄汤的合方，其药有：桂枝、芍药、生姜、炙甘草、大枣、麻黄、杏仁。由于本证小邪在表，稽留日久，又不得小汗出，故见脉浮、发热、身痒等证。古人认为“痒为泄风”，也就是说痒是风邪外泄的一种表现，故此证当因势利导，“汗而发之”。然邪气不甚，如用麻黄汤发汗，则嫌其峻烈；用桂枝汤发汗，则又嫌其太缓。此证既不可不汗又不可多汗，故取桂枝汤与麻黄汤各三分之一的剂量，合和服之，发一点小汗，就可以把病治好。

（2）桂枝二麻黄一汤证

凡服桂枝汤发汗，应以“微似有汗者益佳”，如果发汗太多，不仅病不除，而且还会变生他病。如服桂枝汤发汗后，病人脉洪大，是阳明热象，但不见烦渴的里热证，说明邪仍在表，故可再服桂枝汤发汗解表。切不可因脉洪大过早服用白虎汤，用则将有冰伏邪气，反不得外解之患。若服桂枝汤大汗后，证见发热、恶寒，病形如疟，一日发作二三次，说明虽经汗后，但仍有小邪郁于肌表不解，当须发汗以解表。由于已经发过汗，故不宜发汗太多，用桂枝二麻黄一汤，取桂枝汤剂量的十二分之五、麻黄汤剂量的九分之二，合而服之，使汗出不致过多。

（3）桂枝二越婢一汤证

桂枝二越婢一汤证，是表不解、阳郁而有化热趋势的一种证候，故与上述两个方证有所不同。

太阳病表邪不解，正邪斗争，故发热恶寒，阳气被郁将化热，故发热多恶寒少，脉由浮紧变为微弱。此证虽然从太阳伤寒而来，但由于证情有变，不宜再用麻黄汤；又因表有小邪，但已有阳郁化热趋势，故桂麻各半汤与桂二麻一汤也不能解决问题，当用桂枝二越婢一汤小发汗，以宣解阳郁之邪。

桂枝二越婢一汤，是桂枝汤与越婢汤的合方，由桂枝、芍药、炙甘草、生姜、大枣、麻黄、生石膏组成。此方从药味组成及功能来看，可以说和大青龙汤接近，但大青龙汤证重，本汤证为轻；大青龙汤治不汗出而烦躁，本汤治热多寒少而脉不紧。本证既需发汗又不能大汗，既要发越郁热又不能过于寒凉，故方剂的用量只取桂枝汤二分（相当于四分之一），越婢汤一分（相当于八分之一），小制其剂，发小汗以解郁热。

桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤与桂枝二越婢一汤这三个方子，都有发小汗以解在表之小邪的作用，这是它们的共性，但也有不同之处，尤怡在《伤寒贯珠集》一书中曾合论三方并一一作了比较，可供参考。他说：“桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤，三方并两方合用，乃古之所谓复方也。细审其制，桂枝麻黄各半汤，助正之力，侔于散邪；桂枝二麻黄一汤，则助正之力多，而散邪之力少，于法为较和矣；其桂枝二越婢一汤，本无热证而加石膏者，以其人无阳，津液不足，不胜桂枝之任，故加甘寒于内，少变辛温之性，且滋津液之用。而其方制之小，示微发于不发之中，则三方如一方也。故桂枝汤不特发散邪气，亦能补助正气，以其方甘酸辛合用，具生阳化阴之妙；与麻黄合剂，则能尽麻黄之力，而并去其悍；与石膏同用，则能资石膏之益，而不挠乎权。是虽麻、石并行，而实以桂枝为主，盖非滋养营卫，则无以为发汗散邪之地耳。凡正气不足，邪气亦微，而仍须得汗而解者，宜于此三方取则焉”。

（三）辨不可发汗证

汗法是解表法。太阳病表不解，必须发汗，即“其在皮者，汗而发之”。上面介绍的表实无汗用麻黄汤；表虚有汗用桂枝汤；表实挟热的用大青龙汤；表实挟寒饮的用小青龙汤，都属于汗法。而表有小邪，日久留恋不解，或发热身痒，或寒热如疟，或热多寒少，也应再汗，但不能大发汗，可选用桂麻合方与桂枝越婢合方，属于小汗法。至于邪客经输，项背强几几而有汗的用桂枝加葛根汤，无汗的用葛根汤，无疑也属于汗法之列。可见《伤寒论》中有关发汗以解除表邪的方法是相当全面详尽的。但是，我们应该认识到，人体在疾病过程中之所以能够发汗以驱除外邪，绝不单纯是药物的力量。不管是生理性的，还是病理性的出汗，都是阳气作用于阴液的结果。《素问·阴阳别论》说“阳加于阴谓之汗”，就指出了汗是阳气蒸化津液，出于体表所形成。因此，如果患者阴阳气血不足，特别是津液亏少，就必定缺乏汗源，以致难得汗出；若此时不顾正气之虚，汗源不足，强行发汗，不仅病不会好，而且会发生种种坏病。所以，从这个意义上讲，辨不可发汗与辨可发汗具有同等重要意义，实不可忽视。

辨不可发汗是《伤寒论》，特别是太阳病篇的重要辨证内容之一。《伤寒论》中说：“脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者，不可发汗。何以知然，以荣气不足，血少故也”。就简明地提出了辨可汗与不可汗的依据，以及为什么不可发汗的道理。脉浮紧，是寒邪束表，营卫之气凝涩不利，见无汗、身疼痛，应该用麻黄汤发汗以解表；若虽见身疼无汗，但脉不浮紧而尺脉反迟，或沉、或微，说明患者里虚，荣血不足，汗源不充，就不能再用麻黄汤发汗。“尺中迟”，即尺脉见迟象，是“荣气不足，血少”的反映。因血汗同源，夺血者无汗，强发其汗则必更伤营血，故曰“不可发汗”。

举《伤寒九十论》中凭脉辨不可发汗的病例，供参考：“乡人邱忠臣，寓毗陵荐福寺，病伤寒。予为诊视，其发热、头痛、烦渴，脉虽浮数无力，自尺以下不至。予曰：虽麻黄证，而尺迟弱，仲景云：尺中迟者，荣气不足，血气微少，未可发汗。予以建中汤加当归、黄芪，令饮之。翌日病者不耐，其家晓夜督发汗药，其言至不逊。予以乡人隐忍之，但以建中调理而已。及六七日，尺脉方应，遂投以麻黄汤，啜第二服，狂言烦躁且闷，须臾稍定，已出汗矣，五日愈。”

“尺中迟者，不可发汗”，只是《伤寒论》凭脉辨不可发汗的一个例证。根据“荣气不足，血少故也”的禁汗道理，可以推论，凡见细或微的脉象，均不应发汗。因为微主阳虚，细主血弱，气血虚弱，自然不能再汗。下面再说一说审证而辨不可发汗的几种情况。

“咽喉干燥者，不可发汗”。咽喉是一个重要的门户和通道，有许多经脉从这里通过，特别是有少阴经脉从这里通过，并载阴精以濡润。咽喉干燥不润，反映了少阴心肾精血皆虚，阴液不足之象。这种情况，即使出现麻黄汤证，也不可发汗。若误用发汗法，则阴液益枯，邪未解而正先亡，其后果不堪设想。

“淋家，不可发汗，汗出必便血”。淋，是指小便淋漓不尽，尿意频繁而量少，尿道涩痛的一种病证。初起多属湿热下注，久病即为淋家，多伤下焦之阴。此时若误发其汗，必导致阴津愈伤，火热愈炽，以致灼伤血络，迫血妄行而发生尿血的坏证。

“疮家虽身疼痛，不可发汗，发汗则痉”。久患疮疡的人，叫做“疮家”。由于长期流脓淌血，致气虚血少，营卫衰薄。虽患有身疼痛的表证，也不得发汗。若更发汗，则津液外泄，气血更伤，筋脉失养，可能发生肢体强直、拘挛，甚至牙关紧闭、角弓反张的痉病。

“衄家，不可发汗，汗出必额上陷，脉急紧，直视不能眴，不得眠”。平素常衄血的人，虽患表证，也不可发汗。因为久衄之人，阴血必伤；汗与血同源，更发汗则血益伤。阴血亏虚，经脉、目睛、心神失其濡润滋养，故额上皮肉塌陷，血脉急紧而不柔，目直视而睛不转，神志不宁而不得卧寐。

上述疮家与衄家禁汗的主要原因是阴血已伤，不能再发血虚之汗。由此可知，无论什么原因造成的失血，以致发生亡血病变的患者，均不能再发汗，故《伤寒论》中说：“亡血家，不可发汗”。若不顾阴血的亏虚更发其汗，不但邪不去反而更会虚其虚，使血亡及气，阴虚及阳，肌肤、筋脉失去温煦与濡养，发生身寒、振栗的证候。

禁汗，不仅限于亡血的人，就是经常好出汗的人也要禁汗。经常出汗的人，又称“汗家”。这种人多因卫阳不固，而汗出不止；汗出既久，又可伤津耗液。“汗为心液”，“夺血者无汗”。若更发其汗，则心之阴阳气血更虚。心气虚，心无所主，故发生恍惚心乱而不能安宁的证候；阴液伤，则出现小便后尿道疼痛的症状。对此，《伤寒论》提出了可用禹余粮丸治疗。由于这个方是个阙方，故将《甦生的镜》补禹余粮丸方录下来以供参考：禹余粮、龙骨、牡蛎、铅丹、茯苓、人参。研成末，粳米为丸，朱砂为衣，如绿豆大，空心麻沸汤送下。

最后，还有一种情况也不能发汗，那就是里有虚寒的患者，虽外见表证，也不得发汗。里有虚寒，即阳虚有寒。若更发汗，阳气愈虚，阳虚不能温中，则胃肠冷甚。如果患者素有蛔虫，蛔虫因里寒而上窜，可发生吐蛔的证候；若患者无蛔寄生，则可发生虚寒性呕逆，吐出不消化的饮食物。属于中阳不振的虚寒吐蛔，实践证明，用理中汤加乌梅、蜀椒治疗有效。

以上所列举的咽、淋、疮、衄、血、汗、寒等七种证候，虽有病在上、病在下、病在肌表、病在内脏的不同，但从其不可发汗来讲，它们都有正气不足的特点。凡正气虚损的患者，不管是阴虚、阳虚，还是气虚、血虚，即使有表证存在，也不能发汗。因为发汗是为了祛邪，发汗祛邪还必须依赖于正气的作用，故发汗应以祛邪而不伤正为基本出发点。若不当发汗而强发汗，则必更伤正气，正气不足也就无力拒邪外出，因而也就达不到发汗以解表的目的。由此看来，以上介绍的不可发汗之例，也正是为可汗而设；在可汗与不可汗之中，体现了辨证的观点。

（四）辨传经与不传经

任何病证都不是静止不变的，六经病证也是如此。掌握六经病证的发展变化规律，了解它的来龙去脉，也就是辨别传经与不传经，这对指导治疗和判断疾病的预后有重要意义。六经病证传与不传取决于三个因素：正气抗邪力量的强弱，邪气轻重及其伤人程度，治疗和护理是否及时得当，这些已在概论中讲了，就不再重复。

辨传经与不传经，要以客观脉证为判断的依据，不能拘于发病的时间长短。如伤寒病第一日，多是太阳先受邪。太阳受邪，即为太阳病，应见脉浮、头项强痛而恶寒。一天的病程是很短的，但不能排除病情有变，应该密切观察脉证的变化。如果太阳病的浮脉不变，说明病变仍在太阳之表，没有传入他经，此即“脉若静者，为不传”；若病人的脉证发生了变化，出现了想吐，烦躁不安，脉数急的证候，反映了阳热太盛，邪气有余，是要传经的征象。所以，《伤寒论》中说：“颇欲吐，若烦躁，脉数急者，为传也。”“伤寒一日”，病程短，可能传经也可能不传经；那么病程长了，是不是就一定要传经了呢？《伤寒论》告诉我们的：“伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。”就是说得伤寒病二三日，本有传变的可能，但如果不见烦热口渴等阳明证，和往来寒热、

胸胁苦满等少阳证，说明病情没有变化，病变仍在太阳，没有传到别的经，此时仍应从太阳病的治法解表发汗。

太阳病不仅有传经与不传经的可能，而且还有经尽自愈的情况。

《伤寒论》根据《素问·热论》记载的“七日巨阳病衰，头痛少愈”，提出“太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也”。七日是经气来复之期。太阳病至七日以上，头痛等表证不治自愈，说明因时日的推移，正气日渐恢复，太阳之气旺而有力驱邪外出。所谓“行其经尽”，是指太阳一经行尽，并不是历传诸经。经尽则复，太阳行其经尽，则太阳之气必将来复，因而也就产生可愈的机转。如果经尽不愈，则有传经的可能。表不解，卫阳郁闭化热入里，即可内传阳明。为了防止太阳到阳明的传变，可先针刺足阳明经穴，“使经不传则愈”。根据前人经验，足阳明经穴可选足三里和冲阳。针足三里有增强阳明抗邪能力的作用，刺冲阳可以取得迎泻传入阳明之邪的效果。这种未雨绸缪的治法，具有“治未病”的积极意义。

（五）辨太阳腑证并治

经脉与脏腑相连，阳经系腑，阴经系脏。太阳经为三阳经之一，内系太阳之腑。太阳在经之邪不解，可随经入腑，形成太阳病腑证。若随经之邪，影响膀胱气化功能，形成太阳蓄水证；随经之邪与血相结，便发生太阳蓄血证。

1. 太阳蓄水证治

太阳蓄水证，常可由经证传变而来。太阳病表证不解，或虽经发汗，但汗不得法，均可导致太阳之邪随经入里。在经之邪虽已入腑，但太阳经表之证并未尽解，从而形成了“有表里证”的特点。脉浮、发热、汗出，反映了太阳经邪尚未全解，表证仍在；烦渴欲饮，或饮水则吐，小便不利，反映了太阳之腑受邪，病已由表及里。太阳膀胱为水府，主藏津液，赖气化功能，既可使水蒸腾于上，又可使水排泄于下而为尿。太阳之腑受邪，影响了膀胱气化功能，气化不利，水津不能上承以和阳，故见烦渴欲饮；饮水又不能消，水逆于胃，故水入则吐，成为“水逆”证；水蓄膀胱，不能正常排泄于外，所以小便不利。

此证发热、汗出而烦渴能饮，与阳明病的白虎汤证很相似，然而白虎汤证必口渴舌焦而小便自调，本证则舌苔水滑而小便不利，两证比较，迥然有异，当细心辨识。太阳腑证蓄水，表里经腑同病，用五苓散两解表里。

五苓散由猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝组成。方用猪苓、茯苓、泽泻淡渗以利水；白术助脾气，以使水津四布而不聚；桂枝辛温，既能解肌表之邪，又能通阳化气以行水。药用米汤和服，与服桂枝汤要喝粥的意义一样；并多饮热水，可助药力以发汗解表，化气行水，故《伤寒论》中说“汗出愈”。

五苓散原剂型是用细末状的散剂。“散者，散也”，取其迅速发散的作用，但临床上也可用汤剂或丸剂。因本方作用重点在于化气行水，通利小便，故凡膀胱气化失常，水饮内停而见小便不利者，均可酌情使用，即使没有表证也可以用。

2.太阳蓄血证治

太阳在经之邪，下入于腑，热与血结，形成太阳蓄血证。对于血蓄的部位，《伤寒论》提出“热结膀胱”、“热在下焦”。后世注家又提出许多不同看法，舒驰远根据蓄血的脉证表现和小肠属太阳之说，认为蓄血部位应在小肠，似乎有一定道理。

蓄血有新久之分，热与瘀的程度也有轻重之别，下面就瘀血初结、瘀血已成和瘀血轻证作些介绍。

（1）瘀血初结证治

太阳病不解，在表之郁热随经入里与血相结，从而形成太阳蓄血初结的证候。因热与血结在下焦，其证属实，故少腹拘急，甚至硬痛拒按。太阳与少阴为表里，少阴心主血而藏神，太阳热与血结，浊热上扰少阴，心神不宁，故见烦躁，但未达到狂乱的程度，所以谓之“其人如狂”。

由于此证热与血初结，血结不坚而热气有余，故存在“血自下，下者愈”的机转。如果不能自下而愈，就当用攻逐的方法治疗。但若表证未全解除的，还不能马上攻逐瘀血，应该先行解表，待表解后，再用桃核承气汤攻逐瘀血。

桃核承气汤由桃仁、大黄、桂枝、炙甘草、芒硝组成。方中大黄、芒硝泻热，软坚，破结；桃仁破瘀生新，协同硝、黄攻逐瘀血；桂枝通阳行气，以利血脉；甘草调胃和中以护正。本方内含调胃承气汤，服后有泻利作用，使瘀热从大便出，故方后注“当微利”。

病案举例：李某，年廿余。少腹满胀，身无寒热，坐片刻，即怒目注人，手拳握紧，伸张如欲击人状，有顷即止，嗣复如初。脉沉紧，舌苔黄暗，底面露鲜红色。此病已入血分，《内经》云：“血在上善忘，血在下如狂”也，当用桃核承气汤，一剂知，二剂已。（《遯园医案》）

（2）瘀血已成证治

太阳病六七日，为表邪入里之期。若表证仍在，脉应见浮；今脉微而沉，说明邪已去表入里。沉脉主里，微有滞涩之象，主气血壅滞。邪内陷入里，但又“反不结胸”，说明病位不在上中二焦，又非与痰水互结，而是太阳之邪随经入于下焦，与血相结成为蓄血证。《伤寒论》中以自注句的形式概括了这个证候的病机，即“以太阳随经，瘀热在里故也”，瘀与热结于下焦，故少腹硬满；心神被瘀热所扰，以致发狂不识人；是瘀血，并非蓄水，故小便自利。因本证属瘀血久结，故见少腹硬满、发狂等证较初结之证重。治疗用抵当汤，破瘀泄热。

抵当汤由水蛭（炒）、虻虫（去翅，炒）、桃仁（去皮尖）、酒洗大黄组成。方中水蛭、虻虫为虫类破血药，性峻猛，善破瘀积恶血；佐桃仁、大黄活血化瘀，推陈致新，清泄血热。因本方破坚荡结，力大功专，故取名“抵当”。

《续名医类案》记载一病例：张意田治一患者，七月间患壮热舌赤，少腹闷满，小便自利，目赤发狂，已卅余日。初服解散，继则攻下，但得微汗，而病终不解。诊之，脉至沉微，重按疾急。夫表证仍在，脉反沉微者，邪陷于阴也；重按疾急者，阴不胜其阳则脉流薄急，并乃狂矣。此随经瘀血，结于少腹也，宜服抵当汤。乃自制虻虫、水蛭，加桃仁、大黄煎服。服后下血无算（无法计算，形容很多）。随用熟地一味，捣烂煎汁，时时饮之，以救阴液。

笔者按蓄血证治法则，用抵当汤治精神病，取得满意疗效。附录病例于后，供参考。

王某，女，19岁。患精神分裂症，住某精神病医院，治疗一年，病愈出院。回家后，精神正常，能料理家务，邻居及亲朋都认为她的病已

愈。出院后三个月，发现月事不至，少腹胀痛，心神烦躁，其母亦未介意。又延迟两个月，则旧病复发，开始骂人甚凶，继之则殴打父母，两目发直，脉沉迟有力，舌质紫暗，辨为蓄血发狂，投以抵当汤，两剂而月事来潮，下瘀块甚多，病随之而愈。

（3）瘀血轻证并治

伤寒不解，身有热而少腹满，说明病不在表已入下焦之里。病入下焦有太阳蓄水与太阳蓄血之分，若少腹满而见小便不利的属蓄水；而今少腹满，小便“反利者”，说明是血瘀下焦，即如《伤寒论》中所说“为有血也”。本证只见少腹满，没有急结、硬痛之象，也没有如狂、发狂的证候，故与前证比较，则属于蓄血之轻证，因而不能再用峻猛攻下的汤剂，应用抵当丸下瘀血，缓缓图之。

抵当丸与抵当汤的药味组成相同，只是减少了水蛭、虻虫的用量，加重了桃仁的用量，使其攻逐瘀血的作用比抵当汤缓和。且本方用丸剂，丸者缓也；又一剂分做四丸，每次只服一丸，用量很少，其攻逐力也就更缓。以汤改丸，可连渣服，其药力作用的时间绵长，从而使瘀结荡涤无遗。

以上介绍了太阳腑证，对太阳经证来讲属太阳之里。太阳腑证的成因，可由太阳经证不解，病邪随经入里所致。随经入里之邪与水相结者，为蓄水；随经入里之邪与血相结，即“瘀热在里”的，则为蓄血。少腹急结或硬满，是太阳腑证的共同证。若是水蓄膀胱，气化失职，故见口渴、小便不利；若为血结下焦，浊热扰心，但无碍膀胱气化的，则见如狂、发狂而小便自利。可见，小便之利与不利，对辨太阳腑证之蓄水还是蓄水有着极为重要的意义。

（六）虚烦证治与治疗禁忌

太阳病经发汗吐下后，余热不解，内陷胸膈而致烦，称为“虚烦”。“虚”是指汗吐下后，伤了正气，正欲胜邪而不能，使邪气内陷有可乘之机；另一方面，邪热虽内陷胸膈，但未与痰、水等实邪结聚。因此，不能简单地把虚烦理解为正气虚而致烦的证候。

虚烦证用栀子豉汤治疗，故虚烦证又叫“栀子豉汤证”。下面就通过讲解栀子豉汤证、栀子豉汤的加减证和栀子豉汤的禁忌证，来介绍有关

虚烦的证治与禁忌。

1. 栀子豉汤证

按治疗法则规定，邪在表宜汗，在胸当吐，在腹应下。汗、吐、下法均为邪实而设。若经汗、吐、下后，而见心烦不得眠，说明实邪虽去而余热不解，蕴郁于胸中所致。这种证候发作严重时，可使人反复颠倒，不得卧寐，心中懊恼，烦闷特甚而无可奈何。因为胸中郁热而致烦，故治以栀子豉汤，宣透胸中郁热而除烦。

栀子豉汤，仅由栀子、豆豉两味药组成。栀子苦寒，善清心胸烦热以解火郁；豆豉味苦，能升散邪热之结。两药相须，一宣一降，宣泄火郁而除烦。

虚烦证由于邪热蕴郁心胸不解，而更见心胸窒塞、郁闷甚或疼痛等证的，亦均可用栀子豉汤治疗。

2. 栀子豉汤加减证

虚烦有兼挟证时，当加减化裁栀子豉汤进行治疗，故栀子豉汤的加减证就是虚烦的兼挟证。在栀子豉汤证，即虚烦的基础上，兼见少气的，则在栀子豉汤中加炙甘草以益气；兼呕吐的，则加生姜以降逆止呕；兼腹满的，则去豆豉，加厚朴、枳实理气以消满。若用巴豆制成的丸药峻下之后，而见身热、微烦，说明表里之热虽微，但中焦阳气已受挫，当用栀子干姜汤治疗。栀子干姜汤，即栀子豉汤去豆豉，加干姜，既能清胸中之热，又能温中焦之阳。

3. 栀子豉汤禁忌证

栀子豉汤苦寒走泄，易伤阳气，故《伤寒论》中特别提出“凡用栀子豉汤，病人旧微溏者，不可与服之”。“病人旧微溏”，是指平素大便总是溏泄的患者，多属脾气虚寒，服栀子豉汤后更伤阳气，故不宜服用。

梔子豉汤在原煎服法中有“得吐者，止后服”的说法。其实，梔子豉汤并非涌吐之剂，故多数患者服后并不会致吐；但也有个别人服药后作吐的，这是因为胸脘火热蕴郁太甚，得药力与之相搏，郁极乃发而上逆作吐，故这时的吐是郁开热解而致愈的一种机转。

笔者曾治一患者，王某，男28岁。数日来，心中烦郁，懊^懔难眠，低头不语，家人靠近则挥手斥去。舌红脉数，然大便不结，辨为虚烦之证，服梔子豉汤。当日晚，笔者刚睡不久，即闻有人叩门甚急，出去看，原来是患者之弟。言其兄服药不久，突然呕吐，满头大汗，一家人惶惑不解，让笔者速往诊视。到了他家，患者却已熟睡，次日其病即愈。此例说明服梔子豉汤，确有吐者，这种吐可以看做是郁开热解的一种反映。遇此情况，当不必惊慌。

（七）结胸证治

结胸主要是邪热与痰水互结的一种病证，其病变部位可上至胸中，下及少腹，病变性质属热实者居多。此外，亦有寒痰内结的，则属寒实结胸。

结胸证的形成，有因于太阳病误下，以致表热内陷与水饮结聚而成，如《伤寒论》说：“病发于阳而反下之，热入因作结胸……所以成结胸者，以下之太早故也。”也有虽未经误下，但太阳病不解，邪热内传入里与水饮互结而致的。

根据病位大小、病情轻重以及寒热性质的不同，结胸可分为大结胸、小结胸以及寒实结胸等证候。下面就分别介绍结胸证的几个主要方证。

1.大陷胸丸证

结胸有大小之分，邪气结聚的部位有上下之别。大陷胸丸证，属水热互结的大结胸证，其邪结聚的部位偏于上。其证除见胸中结鞭或疼痛外，并见汗出、项背强急、俯仰困难等证候。此即《伤寒论》中所说：“结胸者，项亦强，如柔痉状”。柔痉，是痉病的一种。痉病，是以项背强急、口噤，或角弓反张为主要临床表现的一种病证。其中无汗者

为刚痉，有汗者为柔痉。水热胶结，势甚于上，以致汗出、项强，能仰不能俯，俯仰艰难如柔痉状，当用大陷胸丸缓下在上之水热。水热去则项背强急得以缓解，故《伤寒论》中说“下之则和”。

大陷胸丸由大黄、葶苈子（炒）、芒硝、杏仁（炒黑）、甘遂、白蜜组成。方用大黄、芒硝泄热破结；甘遂为泻水之峻药，可泻下使水下行；葶苈、杏仁利肺以清泄胸间水热；恐药力太强，泻下迅暴，难以扫尽在上之邪，故制以白蜜之甘缓，且能滋润强急。又本方小制其剂而为丸，只“取如弹丸大一枚”，是峻下制之以缓，以攻为和的方法。

本证有汗出、项强，与桂枝加葛根汤证项背强几几、反汗出恶风，很相似，但病因不同。本证是水热结胸，故当见胸中结硬或疼痛，其势偏于上，影响颈项不和而强急；桂枝加葛根汤证，是太阳中风表虚而经输不利，故见汗出、项背强几几。病因、证候不同，治法各异，临证时应仔细辨认。

2.大陷胸汤证

大陷胸汤证，是水热互结所致的大结胸的典型证候。所谓大结胸，一是指水热互结之势重；一是指水热结聚的范围大，不仅局限在胸间及胃脘部位，表现为“心下痛，按之石鞕”；更有甚者可扩大到“从心下至少腹，硬满而痛不可近”。“从心下至少腹”，说明了病变部位之大；按之像石块一样的硬，以及硬满而痛，不敢用手触摸，又说明了病势之重。大结胸的脉象多见沉紧，沉主里主水，紧脉主实主痛，沉紧脉也是水热结聚成实而致痛的一种反映。

若大结胸证，由“太阳病，重发汗而复下之”，以致津伤邪陷，则还会兼见大便燥结，数日不下，舌燥少津，口渴，午后三五点钟的时候发热（即日晡潮热）等阳明腑实证。

大陷胸汤是泻下水热之峻剂，也是治疗大结胸证的主方。由大黄、芒硝、甘遂组成。大黄、芒硝、甘遂三药互相配合，可破结泄热逐水。其用药量较大陷胸丸为大，且用汤剂，取其速攻力猛。由于本方为泻下之峻剂，故方后注：“得快利，止后服”，以防损伤正气。

从大陷胸汤、丸的制剂及用法看，甘遂均用散剂，不用煎剂，说明古人已知其有效成分不溶于水，煎剂效力差。根据药理研究证明，甘遂泻下的有效成分为一种黄色树脂状物质，不溶于水。

近年来，中西医结合治疗急腹症，用大陷胸汤加厚朴治疗重症肠梗阻、肠腔积液较多，对腹膜刺激征的患者，有一定疗效。

3.小陷胸汤证

小陷胸汤是治疗小结胸证的主方。小结胸，是痰与热互结，其病位正在心下（即胃脘），上不及项背，下不及少腹，疼痛较轻，按之则痛，脉象多见浮滑。《伤寒论》中说“正在心下，按之则痛，脉浮滑”，就概括了小结胸病的脉证特点，并以此与大结胸病“从心下至少腹，硬满而痛不可近”、“脉沉而紧”加以鉴别。大结胸是水热结聚深在胸腹，故脉沉紧；小结胸是痰热结于心下，部位表浅，故脉浮滑。大结胸虽也有心下痛，但不按亦痛，自与小结胸的“正在心下，按之则痛”不同。

小陷胸汤由黄连、半夏、瓜蒌实组成。方用黄连苦寒以泻心下热结，半夏辛降善涤心下痰饮，瓜蒌甘寒滑润能清热除痰以开结。本方与大陷胸汤都由三味药组成。大陷胸汤用大黄，本方用黄连，同可泄热但有强弱之不同；大陷胸汤用甘遂，小陷胸汤用半夏，同有泻利痰水的作用，但有轻重之分；大陷胸汤用芒硝，小陷胸汤用瓜蒌，同为泻利邪结，但又有缓急的区别。所以名为大小，是因为病有大小、轻重、缓急的不同。

《伤寒总病论》有服小陷胸汤“微解下黄涎即愈”的说法，验之临床，确如所言。

孙某，女，54岁。胃脘疼痛，已有月余，痛处微见高起，按之则痛。西医怀疑是癌，建议做钡餐造影，以便确诊。在未检查前，疼痛突然加重，找笔者诊视。察脉弦而滑，苔黄略腻，问其饮食尚可，大便虽通但不畅，小便色黄，心烦急躁。综合分析可知，弦滑脉主痰饮；苔黄腻，反映痰与热瘀；心下高起，按之则痛，为痰热内结，脉络瘀滞于心下之证。

为疏：糖瓜蒌一枚（剪成条先煎），黄连9克，枳实9克，郁金9克，半夏15克。

服一剂痛减大半，再服一剂，大便泻下黄涎，胃脘痛止。

4.三物白散证

大陷胸汤证与小陷胸汤证，即大结胸和小结胸，均属于热实结胸的范围。这里介绍的三物白散证则属寒实结胸。热实结胸当见发热、口渴、心烦、舌苔黄腻或黄燥等热证表现。寒实结胸，则以“无热证”与热实结胸相鉴别。寒实结胸是因寒痰凝结所致。有病在膈上者，可见胸中硬痛；也有病在膈下的，当见心下硬痛，或从心下至腹部硬满而痛。由于寒痰凝结，腑气不通，故还常见大便秘结不下。本证治疗，可用三物白散以温散寒结，除痰逐水。

三物白散由桔梗、巴豆（去皮心，炒黑研细）、贝母组成。因本方用散剂，故取名三物白散。方用桔梗、贝母开胸中结滞以消痰；巴豆辛热，攻寒逐水以破结。因巴豆为烈性泻下药，服之易伤胃气，故应“以白饮和服”。服本方，一般均可泻利，这是寒实邪气排出的正常反应。若不利，可进热粥一杯，以助药力；而利下不止，则可进冷粥一杯以止泻。

5.陷胸汤的禁忌与结胸证预后

大陷胸汤为泻下峻剂，非里实者不可轻投，故只有在太阳表证已解，脉沉紧，里结成实时，才能用此方攻下。如果脉浮大，浮主表，大则为虚，反映表邪未解，里未成实，就不能用大陷胸汤攻下。若误用陷胸汤攻下，则必损伤正气，使里气受挫，在表未尽之邪即可乘虚内陷，形成邪盛正衰的危重证候，所以《伤寒论》中提出：“结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。”

从大结胸的临床表现看，其病证无疑是属大证、重证的。因此，只要里结成实而当下，则应放手急下，祛邪即所以安正，绝不能因循观望，坐失良机。若踌躇不决，失去了泻下祛邪的机会，以致“结胸证悉具”，也就是心下痛，按之石硬，不大便，舌燥而渴，日晡小有潮热，从心下至少腹硬满而痛不可近等诸证俱备，而更见烦躁不宁，说明邪盛正衰，正不胜邪，真气散乱，此时再行攻下则正气不支，不行攻下则邪实不去，故其预后多不良。

结胸病证，虽谓“结胸”，实则病位在于胸膈脘腹，即心下或从心下至少腹，其病变特点是水与热互结。若属于“胁下水”，即水饮结聚在胸胁部位则不属陷胸汤的治疗范围，应该用十枣汤治疗。十枣汤证与陷胸汤证有相似之处，故两证可作比较鉴别。如十枣汤证也有心下硬满堵塞感，但无按之痛或硬满而痛不可近的表现。其辨证要点在于“引胁下

痛”，即呼吸、咳嗽、变换体位时牵引胁肋作痛。由于水饮聚结胸胁，影响三焦气机不利，故还常兼见汗出、头痛、干呕、短气等证。脉见沉弦，舌苔水滑，与陷胸汤证的舌脉亦有所不同。

十枣汤证只是水饮为患，并无邪热，故不用泻热药，只取大戟、芫花、甘遂，以攻逐水饮。又因用毒药峻下，恐伤害脾胃，有损正气，故用肥大枣10枚煎汤，送服药末。这样既可培补中土，扶正以制水，又可监制三药的毒性，取名“十枣汤”的意义也就在此。本方也用于治疗悬饮，“悬饮”即如《金匮要略·痰饮咳嗽病篇》所说：“饮后水流在胁下，咳唾引痛，谓之悬饮。”近代多用于治疗顽固性水肿以及胸水、腹水等，由于本方泻下力猛，故用时当慎重。

《经方实验录》有用十枣汤的病案，现附录于后：张某，男，成人。水饮为患，心悸、胸胀、干呕、短气、胁下疼痛，脉左右皆弦，辨为水饮无疑。治用：炙芫花五分、制甘遂五分、大戟五分，为细末，分两次服。先煮肥大枣10枚使烂，去渣入药末，略煎和服，得下而愈。

（八）心下痞证治

心下痞，是胃脘部感觉堵塞不通的一种病证。其特点是外形看不出有何变化，或见心下突起，按之濡软不痛，但个别也有痛的，如《伤寒论》中所说“按之自濡”、“但满而不痛”，显然与结胸证的“心下满而鞭痛”有别。

痞证的形成，《伤寒论》提出“病发于阴，而反下之，因作痞”和“脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞”，说明本无实邪反下或本属太阳伤寒而误下，均可导致里气不和而邪陷，气机痞塞而成痞。心下即胃之上脘，地处中州，在胸之下，腹之上，为上下交界、气机升降的交通要道。气机上下升降失常，痞塞于中，必致心下痞。根据临床所见，饮食所伤，气郁不舒，以致脾胃不和，也是形成心下痞的主要原因之一。

从病机上讲，痞证主要是气机（气的升降流通）障碍，并非痰、水、食等有形物质的结聚，这与结胸证也是不同的，两者有虚实之分。

1.半夏泻心汤证

半夏泻心汤证，是心下痞满而挟有痰饮的一种证候。它的见证，《伤寒论》中是作为与大陷胸汤证相比较而提出的，即“心下满而鞭痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之；但满而不痛者，此为痞……宜半夏泻心汤。”《金匱要略·呕吐下利病脉证治篇》则作了较为详细的描述：“呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之。”从两书所举之证并结合临床可以看出，心下痞满、呕恶、肠鸣下利或大便不调、脉弦滑、苔白腻等，是为半夏泻心汤的辨证要点。本证是由于脾胃不和，升降失序，中焦痞塞，寒热错杂，痰饮内生所致。胃气不降则恶心呕吐；脾气不升，故肠鸣下利；气机痞塞于中，故心下痞满。用半夏泻心汤苦降辛开，和胃降逆，涤痰化饮。

半夏泻心汤也属和解剂之一。方由半夏、黄芩、黄连、干姜、人参、炙甘草、大枣组成。因气机升降不利，中焦痞塞，胃气不降而生热，故以芩、连之苦寒以降之；脾气不升而生寒泻利，故用干姜之辛热

以温之；痰饮扰胃，上逆作吐，故用半夏化饮降逆以止呕；脾胃气弱，不能斡旋上下，故以参、草、枣以补之。本方清上温下，苦降辛开，蠲痰消痞，为治疗心下痞的主方。

介绍一个病例：张某，男，36岁。素有酒癖，因病心下痞闷，时发呕吐，大便不成形，日三四行，多方治疗，不见功效。脉弦滑，舌苔白。此证为酒湿伤脾，升降失调，痰从中生。痰饮逆胃则呕吐，脾虚气陷则大便不调；中气不和，气机不利，故作心下痞。拟方：半夏12克、干姜6克、黄芩6克、黄连6克、党参9克、炙甘草9克、大枣7枚。服一剂，大便泻出白色黏涎甚多，呕吐遂减十分之七；再一剂，则痞、利俱减，又服两剂则病痊愈。

2. 生姜泻心汤证

生姜泻心汤证，是心下痞满而挟有水气的证候。其主要脉证：心下痞硬，噫气带有食臭味，肠鸣有声，泻利，胁下阵痛，或见下肢浮肿，小便不利，脉沉或弦，舌苔水滑。本证和半夏泻心汤证在病机与证候上有相似之处，均属脾胃不和，升降失常，气机痞塞的病变，心下痞是它们的共同见证。不同的是半夏泻心汤证挟痰饮，生姜泻心汤挟水气。本证由于脾虚不运，水邪流于胁下，或走于肠间，故见胁痛、肠鸣、下利；脾虚不能消谷，故见消化不良、干噫食臭等。

生姜泻心汤即半夏泻心汤另加生姜并大其用量，而减少干姜的用量，从而使本方加强了宣散水气的作用，若见小便不利，可加茯苓以淡渗利水。

病案举例：潘某，女，49岁。心下痞塞，高起如拳，暖气频作，呕吐酸苦水液，肠鸣漉漉，大便溏，饮食不思，日见疲惫。脉滑按之无力，舌胖嫩，苔水滑，面虚浮而黄。触按其胃脘部，似有块物，但重按即无，抬手又起，中空无物，故属气痞。拟方：生姜15克、干姜3克、黄连3克、黄芩6克、党参6克、炙甘草9克、半夏9克、茯苓18克、大枣7枚。服二剂，则心下块物消退，饮食好转。照原方又进二剂，诸证皆除。为巩固疗效，又服二剂而痊愈。

3. 甘草泻心汤证

甘草泻心汤在《伤寒论》中用于治疗太阳表证几经误下，以致中虚邪陷客气上逆而形成的心下痞证。“客气”是对人身的主气即正气而言，也可以说就是内陷的邪气。凡表不解，均不可下，如误下，必损伤脾胃之气。脾胃气虚，水谷不化，则肠鸣下利日数十次；升降失常，气机不利而痞塞，寒热格拒而错杂于上下，故见“心下痞鞭而满，心烦不得安”。这种痞硬并非下后实热内结，而是外邪本微，攻下太峻，使胃虚邪陷，客气上逆所致。若再误把虚当成实治，复用攻下的方法，则必致胃气更虚，心下之痞更甚。

甘草泻心汤所用药物，同于半夏泻心汤。唯重用炙甘草以扶下后之胃虚，除客气之逆，为强主弱客之法。《伤寒论》中甘草泻心汤本无人参，但《金匱要略》、《千金方》、《外台秘要》均有人参，而且半夏泻心汤、生姜泻心汤中也都用人参，本方证属下后胃虚，益胃补虚当用人参，故在原方中加人参。

4. 大黄黄连泻心汤证

前三个泻心汤证，在一定程度上都具有上热下寒、寒热错杂的特点，而大黄黄连泻心汤证属于热气痞的证候。因于无形热邪结聚心下，故见心下痞，按之软而不硬：阳热邪气痞塞于中焦气分，故“其脉关上浮”。脉有寸、关、尺三部，可分候上、中、下三焦的病变。关脉浮，是中焦阳热盛的表现，本证虽无有形实邪结聚，但属热证，故当见心烦、尿赤、舌红苔黄，甚或脉数、吐衄等证。

大黄黄连泻心汤，由大黄、黄连两味药组成。大黄、黄连苦寒以泻心胃之火热。因是气痞，无燥实邪气可泻，故药不用煎煮法，而用“麻沸汤”即滚开水渍泡取汁，意在取其气而薄其味，作用在于清热以消痞，不是泻下以去实。

曾治孙某，男，60岁。病鼻衄而心烦，心下痞满，小便色黄，大便不爽，舌苔黄，脉寸、关皆数。辨为心胃之火，上犯阳络，胃气有余，抟而成痞。用大黄9克、黄连6克、黄芩6克，以麻沸汤浸药，只饮一碗，其病应手而愈。

5. 附子泻心汤证

附子泻心汤证，是热痞又兼表阳虚的证候。其临床表现在热痞见证的基础上，病人反见“恶寒汗出”之证。发热、恶风、汗出者，是太阳中风；今无热而恶寒汗出，是卫阳不足之象。卫阳即表阳，出于下焦，是肾中阳气所化生，达于体表即可“温分肉、充皮肤、肥腠理，司开合”。下焦阳虚，则卫阳化生不足，失去其温煦和固护肌表的功能，故见恶寒、汗出，治疗用附子泻心汤。

附子泻心汤的药物组成是：大黄、黄连、黄芩、炮附子。方用大黄、黄连、黄芩苦寒泄热以消痞，附子温经扶阳。以麻沸汤浸三黄，而另煮附子取汁兑服，意在泄热轻、扶阳重。

《遯园医案》记载一病例：宁乡学生某，得外感数月，屡治不愈。延诊时，自云：胸满，上身热而汗出，腰以下恶风。时夏历六月，以被围绕。取视前所服方，皆时俗清利、搔不着痒之品。舌苔淡黄，脉弦。与附子泻心汤，阅二日复诊，云药完二剂，疾如失矣，为疏善后方而归。

6.旋覆代赭汤证

旋覆代赭汤证，是属胃虚挟饮，肝气上逆的心下痞证。伤寒发汗后，又误用吐、下，表证虽解，但胃气已虚，胃虚则肝气来乘，水谷不得运化而变生痰饮。痰气痞塞，故心下痞满；气逆不降，故暖气频作，而痞仍不解，此即“噎气不除”。本证之脉多见弦滑，但按之却软。

旋覆代赭汤由旋覆花、代赭石、人参、生姜、半夏、炙甘草、大枣组成。旋覆花消痰下气散结，代赭石重镇降逆，二药配合使用，善能降气以治噎呃；半夏、生姜辛温而开，可涤痰散饮而消心下痞硬；人参、甘草、大枣益气补中，使中气运则津液布，痰饮除则气道通，气机得利则痞噎自除。

用本方时，药物剂量当调配适当，否则会影响疗效。一次笔者带毕业生实习，某学生治一妇人，病心下痞而暖气频作，断为痰气上逆，予旋覆代赭汤，服药不见效，因而请笔者为之诊治。笔者全面地检查了患者，断定该生诊断无误，用方也对，但为何不效？细审其方，发现代赭石用了30克，生姜却只用3片。笔者对这个学生说，问题就出在这里。因为痰气盘踞中焦成痞，挟肝气上出于胃为暖气，但方中不能重用生姜以散饮消痞，即不能奏克敌制胜之权；又重用代赭石重以镇逆，使药力直趋而下，不能协旋覆花以理肝气之逆，也就是方药虽对证，但药用剂

量不称，所以无效。遂改生姜为15克、代赭石为6克，再服果然见效。

以上介绍了“心下痞”的六个方证。掌握了这六个方证，虽不能概括全面，但也可以说是抓住了主要内容。一般地讲，凡心下痞证，服泻心汤，多能治愈。若服泻心汤，“痞不解”，并见烦渴、小便不利的，说明是因水饮内停，阻塞气机而成痞，故用泻心汤无效，应该用五苓散，使其小便通利则愈。

寒热上下错杂，气机痞塞于中而成心下痞，当用泻心汤，已如上述。若“伤寒胸中有热，胃中有邪气”，虽属上热下寒、寒热错杂，但不见心下痞，亦不能用泻心汤，应以黄连汤清上温下，平调寒热。“胸中有热”，即热在上，使胃气不降，故病人总想呕吐；“胃中有邪气”，即寒在下，使气血凝滞，脾气不升，故见腹痛，或下利。黄连汤内有黄连、炙甘草、干姜、桂枝、人参、半夏、大枣等七味药。方中用黄连以清胸中之热，干姜温脾胃之寒，桂枝宣通上下之阳气，半夏降逆止呕，人参、甘草、大枣益胃安中，使之有利于斡旋上下，调理寒热阴阳。

黄连汤与半夏泻心汤仅有一药之差，即半夏泻心汤去黄芩，加桂枝，则成黄连汤。二方比较，黄连汤用桂枝，偏于温通，多用治上热下寒，阴阳不和，呕吐腹痛等证；半夏泻心汤有黄芩，偏于清热，常用治胃气不和，心下痞满，呕吐下利等证。柯韵伯说：“此与泻心汤大同，而不名泻心者，以胸中素有之热，而非寒热相结于心下也。”徐灵胎又说：“诸泻心之法，皆治心胃之间寒热不调，全属里证；此方以黄芩易桂枝，去泻心之名而曰黄连汤，乃表邪尚有一分未尽，胃中邪气，尚当外达，故加桂枝一味以和表里。”这两位注家的意见，可供我们参考。

介绍一个病例：徐州李某，呕吐而大便作痢，日三四行，里急后重，有红白黏液。病经一载，各处就医而病不愈。因事来京，经朋友介绍，让笔者为之诊治。脉弦而滑，按之无力，舌红而苔白，此乃寒热错杂之证。若只治其一，或以寒治热，或以热治寒，皆不能奏效。当寒热并用，仿黄连汤法，拟方：黄连9克、干姜9克、桂枝9克、半夏9克、人参6克、炙甘草6克、大枣7枚。前后共服六剂，一载之疾，从此而愈。

（九）辨太阳病变证治法

“变证”是指经过误治后，病情发生了变化，甚至是被治坏了的病证。它的证候类型很多，虽然是从太阳病误治而来，但其病变却远远超出了太阳病的范围。因此，我们在这里另立一节加以讨论。

一般地说，凡属太阳病，无论中风或伤寒，也无论主证和兼证，均有它们各自的规律。而太阳病的变证就不同了，它的形成原因复杂，病情多变，出入于阴阳、表里、寒热、虚实之间，而不受六经传变规律的约束。正因为它跳出了六经传变的圈子，所以学习它，对于提高我们辨证论治的水平，以指导临床实践，就有着极其重要的意义。

太阳病变证，从《伤寒论》中所举的内容看，多来自于太阳病汗、吐、下等误治之后。虽然不能排除汗、吐、下诸法用不得当，均可导致病情变化而形成变证甚或坏病，但也不能拘泥一切变证都是从汗、吐、下误治而来，或断言汗后一定发生什么病变，吐后、下后又一定发生什么病变，而应该把汗、吐、下等误治看做是引发变证的一个条件和转机。至于有关变证的辨证与治疗，则还要按照《伤寒论》所提出的“观其脉证，知犯何逆，随证治之”的原则，以客观脉证为依据，具体情况作具体分析，灵活对待，灵活处理。

1.表里先后、标本缓急与调整阴阳的治疗法则

在介绍变证的具体内容之前，先讲一讲表里先后、标本缓急的治疗法则，这不但对变证的治疗有指导意义，而且也是防止发生误治的根本保证之一。

急则治标，缓则治本，是指导治疗的原则。凡表里同时俱病，按常规治法，应先解表，而后治里。但在具体运用时也不可拘泥，应视表里证候的缓急而决定治疗的先后。若表证急，本应先发汗以解表而反用下法以攻里，属治不得当，故《伤寒论》中说“本发汗，而复下之，此为逆也”；若先发汗，则为恰当的治法，故曰“治不为逆”。反之，里证急，表证缓，本应先下以治里，而反用汗法治表，也是不合适的，若先行以救里急，而后再汗，则治不为逆。标本缓急的另一治法：患者既有

下利清谷不止的少阴寒证，又有身体疼痛的太阳表证，如果拘于先表后里的治疗法则，应先发太阳之汗以解表；但下利清谷，阳虚阴盛，为本已虚，再发虚人之汗，必伐少阴之根。在这种情况下，既然少阴本证为急，太阳标病为缓，便当急以四逆汤（方见《少阴病篇》）先温其里；大便调和，里证已愈，而表仍不解，则当再用桂枝汤急救其表，以防表邪内传。所以，用桂枝汤而不用麻黄汤解表，是因本属里虚，正气方复，不当峻汗之故。再如“病发热头痛”，是太阳表证；表证当见浮脉而反见沉脉，说明兼有少阴之里虚，证属太阳、少阴的表里“两感”证，治疗当解表温经并施，用麻黄附子细辛汤（方见《少阴病篇》）。若服麻黄附子细辛汤表里兼治，病仍不愈，反映了少阴阳虚为甚，当急用四逆汤以温少阴之阳，不仅增强了太阳的抗邪能力，而且加强了解表的功能，即“扶正以祛邪”。

由于滥用汗、吐、下等治法，促使太阳病发生了变化，成为变证或坏病，则应“观其脉证，知犯何逆，随证治之”。这是处理误治变证的一条总则。但也有一些治坏了的病证，由于患病机体存在着一定的抵抗外邪和自然修复的能力，亦可不治自愈。《伤寒论》中说：“凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。”讲的就是这种情况。“凡病”，是泛指一切疾病。若用汗、吐、下等法以祛邪，是指的有余之病。若亡血、亡津液，是指的不足之证。为此，虚证也好，实证也好，不管是什么样的疾病，就其最基本的病理变化来说，均属阴阳的偏盛偏衰，即阴阳失调。若通过患病机体本身的能动作用，使阴阳得以调整而达到自和，病就可以自愈；若不能自愈，就需借助于各种治疗方法来调整阴阳。但不管用什么方法治疗，实际上都属外界条件，只有通过内因，即促使患病机体的阴阳协调和合，才能达到治疗目的。为了进一步说明这个道理，《伤寒论》还举了汗、下而致亡津液，不治自愈的例证：“大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也，勿治之，得小便利，必自愈。”下后复汗，伤了机体津液，发生一时性的小便不利，不要误认为是停水而用利尿药物再伤津液；只要患者气化功能不衰，饮食水谷能够不断化生以补充，待小便自然通利时，说明津液已复，阴阳自和，病也就好了。这里虽然讲的是疾病自愈的道理，但同时告诉我们，治疗疾病也在于调整阴阳，使其达到相对的平衡，就是说达到“阴阳自和”，亦为治疗疾病的基本出发点。

2.邪热迫肺作喘证治

太阳病或汗或下，治不得法，表邪不解，化热内犯于肺，肺受热迫津液外渗，故见汗出而热不解；肺失清肃宣降之职，故气逆作喘。汗出而喘，但不恶风寒，故“不可更行桂枝汤”，也就是不属于桂枝加厚朴杏仁汤证；汗出而喘，“无大热”，说明也不属于阳明里热，是既非表又非里，而为邪热迫肺之证。因肺主气，司呼吸，故凡咳喘气逆的病证，当首先考虑是肺的病变。所以《伤寒论》中指出“汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤”，以清热宣肺而定喘。

麻黄杏仁甘草石膏汤，用麻黄宣肺开郁，佐杏仁利肺平喘，重用生石膏以清肺热，甘草和中益气，配石膏又可甘寒以化生津液。汗出用麻黄，无大热用石膏，似属不妥，实则麻黄协桂枝方能走表发汗，若与石膏相配伍，则重在宣泄肺热而不在于发汗，故本方有汗、无汗，身有大热或无大热，均可服用。本方临床用治肺炎、气管炎、鼻窦炎等病而属于肺热者，均有一定疗效。

举一个病例：郑某之子，初春出麻疹，疹未齐而骤回。身热高至39.8℃，气喘鼻扇，环口发绀，证情十分严重，脉数而滑，舌苔黄褐而干。此证为疹毒内陷，火热刑金之证。治当宣肺清热，透疹外出。麻黄2.4克、杏仁9克、桑叶6克、生石膏18克、羚羊角1.2克、瓜蒌仁6克、浙贝6克、甘草1.5克。服一剂热退而喘平，前胸后背透发疹点甚多。但咳嗽仍甚，转方以桑菊饮加蝉衣、贝母、竹茹、玉竹等药，调理而愈。

3.协热下利证治

本为太阳中风桂枝汤证，不当下反用下法，以致邪陷于里下利不止，若脉由浮缓变为急促，说明阳气有余，仍有抗邪外达之势，是“表未解也”；邪陷化热，上熏于肺，外蒸于肌表，故见“喘而汗出”。肺合皮毛，与大肠相表里，表不解而邪内陷，则肺与大肠俱热，故协热下利，喘而汗出，宜用葛根黄芩黄连汤解肌清热，表里兼治。

葛根黄芩黄连汤由葛根、黄芩、黄连、炙甘草组成。葛根既能辛凉解表，又能升腾津液，起阴气而止泻利；芩、连苦寒，清里热，厚肠胃而止利；甘草和中安正。本方既能外解表热，又能清解里热，故为表里两解之剂。临床用治表不解而又有热泻、热痢的病证，疗效很好。

桂枝加厚朴杏仁汤证、麻杏甘膏汤证、葛根黄芩黄连汤证均有汗出而喘，但其病变是不同的。桂枝加厚朴杏仁汤证与麻杏甘膏汤证，虽病变重点都在肺，但有寒热之别；麻杏甘膏汤证与葛根黄芩黄连汤证，虽

然皆以热邪为主，但有热在于肺、以喘为主，热在于肠、以泻利为主的不同，临证时当加以鉴别。

4.误治变虚证治

太阳病汗不得法，或误用吐下，均可伤及正气而形成虚证。因《伤寒论》的主要内容是讲寒邪伤阳而致病，故太阳病误治变证，是以伤阳而成阳虚证者居多。

（1）心虚作悸证

太阳病本应发汗，但不能发汗过多，汗为心之液，是阳气蒸化津液而成，汗出过多则心阳随之而耗，心脏失去阳气的庇护，则空虚无主，而见悸动不安。实则拒按，虚则喜按。心悸而常以手捂住心窝部，即“叉手自冒心，心下悸，欲得按”，是正气不足的一个标志。心阳虚作悸，当用桂枝甘草汤甘温补心。

桂枝甘草汤，仅桂枝、炙甘草两味药。桂枝辛温补心阳之虚，甘草甘温益气和中而滋血脉。本方辛甘合化为阳，补心阳而不燥，滋血脉而不寒，药少力专，为补心阳的基本方。

马元仪治一妇，病经一月，两脉浮虚，自汗恶风，此卫虚而阳弱也。与黄芪建中汤一剂，汗遂止……越一日，病者叉手自冒心间，脉之虚濡特甚，此汗出过多而心阳受伤也。仲景云：发汗过多，患者叉手自冒心，心下悸欲得按者，桂枝甘草汤主之。与一剂良已。（引自《印机草》）

（2）心虚烦躁证

太阳病不用麻桂发汗，而以火劫发汗，后又用攻下的方法，不仅伤其心阳见心悸欲按，而且心神亦浮动不安而更见烦躁。“火劫”是指烧针、温针、熏、熨、灸等火攻的方法，强行胁迫发汗（“劫”与“胁”，古字通用）。凡误用火攻所引起的变证，则称“火逆”。有关火逆的变证，后边还有专题介绍。这里所介绍的火逆是指烧针（把针体烧热再行针刺的方法，谓之烧针）用以劫汗，而伤了心阳。《素问·生气通天论》说：“阳气者，精则养神”。心主藏神，今心阳虚，神失所养，故见心悸而烦躁不宁。治疗用桂枝甘草龙骨牡蛎汤补益心阳，安神定悸。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤，用桂枝、甘草以复心阳之虚，龙骨、牡蛎潜阳镇逆，收敛心气以安神定悸。

（3）心虚惊狂证

本证可以说是心虚烦躁证的进一步发展。因为“伤寒脉浮”，是病在表，应当发汗，若误“以火迫劫之”，即用火攻的方法强行发汗，则必致汗出过多而伤亡心阳，轻则见心悸、烦躁，重则心气散乱，心神浮躁而见惊悸、狂躁、卧起不安等证。且阳虚则水津不化，而易凝聚为痰饮；痰浊邪气乘心气之虚而上扰，也是导致神志不宁，出现精神症状的重要原因之一。心虚惊狂证，宜用桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤治疗。

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤，既可以说是桂枝汤的变方，又可以说是由桂枝甘草龙骨牡蛎汤加味而成。其组成药物有：桂枝、甘草、生姜、大枣、牡蛎（熬）、蜀漆、龙骨。用桂枝、甘草以扶心阳之虚；生姜、大枣以调营卫之气；此证重在阳虚，当避阴就阳，故去芍药；涤痰逐饮须加蜀漆；牡蛎、龙骨，不仅兼能化饮，而且能敛神定志以治惊狂。因本方主治的证候由火逆所致，故取名“救逆”。

（4）心阳虚欲作奔豚证

奔豚的豚，即小猪。因本病发作时，有气从少腹上冲于胸，甚或直达咽喉，就好像小猪自下向上奔窜一样，故名。

患者素体阳虚，或汗多伤阳，心阳虚不能制水，水邪冲动，故“其人脐下悸”。脐下即少腹，位居下焦而属于肾。脐下悸动，而气未上冲于心胸，说明是肾水初动，故称“欲作奔豚”。下焦肾水所以欲动，其病源在于上焦心阳不足，故用茯苓桂枝甘草大枣汤温心阳，伐水邪。

茯苓桂枝甘草大枣汤重用茯苓以伐水，桂枝助心阳而降冲逆，甘草、大枣益气健脾，培土以制水。本方要求用甘澜水煮药，义在不助水邪。《伤寒论》中介绍了作甘澜水法：“取水二斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。”以杓反复的扬水，炼之使甘，以缓其水寒之性。

（5）心阳虚已发奔豚证

若用烧针强行发汗，即“令其汗”，必损心阳；阳虚卫外不固，针处又被寒邪所乘，阳虚感寒，心火上衰则肾水无制，水寒之气冲逆于上

则“必发奔豚”，患者感觉“有气从少腹上冲心”，甚至上冲至咽喉，发作欲死。治疗方法，可先用艾炷灸针处各一壮，温以散寒；然后与桂枝加桂汤，强心阳，降冲气。

桂枝加桂汤，即桂枝汤加重桂枝用量，如《伤寒论》中所说“更加桂二两”。桂枝辛温，可益心阳，散风寒，降水气。本方重用桂枝的目的，就在于强心阳以降水寒冲逆之气，正如方后所注：“以能泄奔豚气也。”桂枝加桂汤，是加桂枝还是加肉桂，其说不一。方有执认为：“所加者，桂也，非枝也”。但从《伤寒论》中“更加桂二两”、“今加桂满五两”等句分析，还是加桂枝为对，而不是加肉桂。

病案举例：崔某，女，50岁。其病颇奇，自觉有一股气，从两足沿阴股一侧往上行，至小腹则胀，至心胸则悸、闷，头出冷汗。少顷，气往下行，诸证亦随之而消。每次发作均有欲死的恐怖感，精神极为紧张。素患腰酸，腰冷，带下等证。面色青黄不泽，舌质淡嫩，苔白而润，脉弦数无力。此证当属奔豚，然而气不从少腹却沿少阴经脉上窜，实为临床所罕见。凡上冲之证，多因在上之阳不足，制水无力导致阴邪上干。今阴来搏阳，所过之处而见其害，或胀或悸；阳与阴争，故脉虽数而按之无力。弦为阴脉，水饮病可见弦脉。舌淡苔白，无疑也是阳虚的表现。方以桂枝加桂汤以伐肾邪而降逆，另送黑锡丹二钱温阳镇冲。每隔一日服一剂，服五剂病愈。

（6）心阳虚水气上冲证

太阳病或吐或下，外邪虽解，然心阳受伤，中气受挫，水无制上冲而为病，故见“心下逆满，气上冲胸”；胸阳不振，水气凌心，故见心悸；水气阴浊上蒙清阳，所以头目眩晕；脉沉主水，紧则为寒，脉沉紧是水寒为病。治当温阳化水，宜茯苓桂枝白术甘草汤。若更发汗，则愈伤阳气。“阳气者……柔则养筋”，阳虚不能柔养筋脉，则会出现肢体震颤摇动的证候。

茯苓桂枝白术甘草汤，用茯苓淡渗利水，桂枝温阳降冲，白术、甘草健脾补中筑堤以制水泛。本方在《金匮要略》中用治痰饮：“心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之”，“夫短气有微饮，当从小便去之，苓桂术甘汤主之”，据笔者个人经验，若患者痰盛，可于本方中加半夏、陈皮；若头目眩晕为甚而因于饮者，可加泽泻；若兼见血压偏高者，可酌加化瘀之药如红花、茜草、牛膝等。

病案举例：陈某，女，52岁。素有大便秘结，常五六日一行，坚如羊屎。口干渴，但饮又不多。每到夜晚，自觉有气从心下上冲，继而头

晕、心悸、气短、胸闷等证俱见。身有轻度浮肿，小便短涩不利，颜面虚浮，目下色青。脉沉弦，舌胖嫩，苔水滑。此证水病似燥，因津液不得敷布而致。水为阴邪居于下，病则必犯阳气而逆于上，所以证见头晕目眩、胸满、心悸；水邪不去，则气化不行，津液不布，故上见口干而渴，下则小便不利，大便秘结。更参其脉与舌，确定心阳不足，水气为患无疑。为疏：茯苓30克，桂枝9克，白术6克，炙甘草6克。服两剂则头晕、心悸减，原方又加肉桂3克，助阳以消阴；加泽泻12克，利水以行津。又服两剂，小便自利，大便每日一行，面色转红，诸证随之而愈。

（7）心虚动悸脉结代证

《伤寒论》中说：“脉按之来缓，时一止复来者，名曰结。又脉来动而中止，更来小数，中有还者反动，名曰结，阴也。脉来动而中止，不能自还，因而复动者，名曰代，阴也。”从上述可知，结代脉属于搏动缓慢而有歇止的一种脉象。其中，歇止时间短，复跳稍快的，即“更来小数者”，是结脉；歇止时间长，即“不能自还，因而（有曰“略久”，有谓“良久”）复动者”，是为代脉。今之脉学，则更以止无定数和止有定数来作为区分结脉与代脉的标准。结脉主气血凝结，亦见于气血不足；代脉主脏气衰微，气血亏虚，亦见于七情惊恐，跌仆损伤。

心主血脉，心脏气血素虚，又感寒邪，正虚邪扰，甚则动摇心宫，而致气血不续，故脉来结代；心虚不能自主，所以心动悸非常。治以炙甘草汤益气养血，复脉定悸。

炙甘草汤由炙甘草、生姜、人参、生地黄、桂枝、阿胶、麦冬、麻子仁、大枣组成。炙甘草益气补中，化生气血，以复脉之本，为主药；人参、桂枝、生姜益心气，通心阳；生地黄、麦冬、阿胶、麻仁、大枣补心血，滋心阴，以充养血脉。以清酒煎煮药物，可通经络利脉道，又使药力不滞。全方益阳滋阴相互为用，使阳能助阴则脉复，阴能助阳则心动悸自安，脉亦自和。因本方具有复脉的功能，故又名“复脉汤”。

本方对功能性心律不齐、期前收缩有较好疗效。本方去人参、桂枝、生姜、大枣，加白芍，名加减小复脉汤，治阴血虚脉结代，心动悸。温热病后期，真阴大亏，虚风内动，心动悸，以加减小复脉汤去麻仁，加牡蛎，名一甲复脉汤；加牡蛎、鳖甲，名二甲复脉汤；加牡蛎、鳖甲、龟板，名三甲复脉汤。

病案举例：郑某，男，56岁。经常头晕，鼻衄，心烦少寐，耳鸣如蝉，不时有失神欲倒的感觉。视其人身材高大，面赤如丹，舌红苔少，

脉弦而结。此证为心肾之阴双虚，以致阴不潜阳，肝风鸱张，上旋清窍。为疏：生地30克、麦冬24克、龟板18克、白芍12克、炙甘草12克、玄参12克、石决明30克、生牡蛎30克。服两剂而神倦思睡，日夜不醒；二日后，神爽清醒，头晕耳鸣大有好转，脉虽弦但已不结。转方又加鳖甲、五味子，服十数剂，渐愈。

（8）心肾双虚证

发汗过多，伤损心阳，则“其人叉手自冒心，心下悸，欲得按”，属桂枝甘草汤证。若更“重发汗”，不仅心阳愈虚，且必伤及肾阳。肾为先天之本，肾中元阳为一身阳气之根，诸脏阳虚，穷必及肾。肾开窍于耳，肾虚则“必两耳聋无所闻也”。许叔微说：“伤寒耳聋，发汗过多者，正气虚也。”本证在心阳虚的基础上更见肾虚耳聋，则非桂枝甘草汤所能治，而应考虑用桂枝甘草汤加参附以补心肾之阳气。

（9）胃虚水停证

太阳病发汗不当，可伤太阳之气，外邪随经入里，影响膀胱气化功能，以致形成津不上承而口渴，水蓄膀胱则小便不利的五苓散证；若伤及中焦胃阳，胃虚不能游溢水精，以致水邪停留而不化，可见心下悸动，按之应手，胃脘部有振水声和如囊裹水之感。因胃虚水停中焦，无碍膀胱气化，故小便自利而口不渴。《伤寒论》说：“伤寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之。”不仅指出了胃虚水停的治法方药，并以渴与不渴作为五苓散证与茯苓甘草汤证的主要鉴别点。

茯苓甘草汤由茯苓、桂枝、生姜、炙甘草组成。方用桂枝、茯苓通阳利水，生姜温胃以散水，甘草补脾和中。若服药后，患者由不渴转为渴欲饮水，是为水去阳布而欲愈的好现象。临床用本方，若能配合茯苓饮（茯苓、人参、白术、枳实、橘皮、生姜）同用，则效果更佳。

（10）脾虚烦悸证

太阳病仅二三日，即见心悸而烦，说明不是外邪传经入里所致，而是病者中气虚，素禀不足。脾胃中气为后天之本，气血荣卫化生之源。脾胃虚，中气弱，气血化生不足，心失所养，故“心中悸而烦”；荣卫不足，虚而内怯，抗邪无力，故外证亦难以速解。此时当用小建中汤补脾建中，扶正以驱邪，里气壮则表自解。

小建中汤是桂枝汤的一个变方，即桂枝汤倍用芍药的剂量，再加饴

糖而成。方中以桂枝调和荣卫；倍用芍药，以滋荣血而利血脉；加甘温之饴糖，补中扶虚缓急。此方从中州变生气血，以治悸烦与腹痛等证。所谓建中，即建立中气的意思。

病案举例：张一尹近川翁，始以内伤外感，过服发散消导之剂，致胃脘当心作痛，六脉皆弦而弱，此法当补而敛之也。白芍五钱，炙甘草三钱，桂枝一钱半，香附一钱，大枣三枚，饴糖一合，煎服，一帖而瘳。（引自《赤水玄珠》）

（11）脾虚气滞腹胀证

“发汗后，腹胀满”，表证虽解，但因脾气素虚，发汗更伤脾气，脾虚运化失职，气壅湿滞所致。此证，补中则愈塞，攻之则愈虚，既属虚中挟实，则治当补中有行，用厚朴生姜半夏甘草人参汤。

厚朴生姜半夏甘草人参汤用厚朴宽中除满，生姜辛开理气，半夏开结燥湿，人参、甘草健脾培土以助运化。临床实践证明用此方时，人参、甘草等补气药的量不宜大，而厚朴、半夏、生姜等行气散结药的用量不宜小，即掌握三补七消的比例，方能取得较好疗效。

病案举例：张石顽治总戎陈孟庸，泻利腹胀作痛，服黄芩、白芍之类，胀急愈甚，其脉洪大而数，按之则濡，气口大三倍于人迎，此湿热伤脾胃之气也，与厚朴生姜半夏甘草人参汤二剂，痛止胀减，而泻利未已，与干姜黄芩黄连人参汤二剂，泻利止而饮食不思，与半夏泻心汤而安。（引自《张氏医通》）

医案中之“气口”，指右手脉；“人迎”，指左手脉。凡内伤脾胃之气，则气口脉大于人迎；凡外感伤寒之邪，则人迎脉大于气口。察人迎与气口，可作为辨内伤与外感的依据之一。

（12）中寒吐逆脉证

胸膈胃脘阳气素虚之人，再发汗则阳愈虚，阳虚浮动，所以脉来反数。脉数主热，但有真假之分，阳盛而热者，脉当数而有力，消谷能食；虚阳浮动而见数脉，是属假热，也就是《伤寒论》中说的“数为客热”，必按之无力；阳虚不能腐熟消化水谷，因而不能食，或食后谷不化，胃气上逆而作吐。《伤寒论》中所说：“此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。”就是对中寒吐逆的脉证、病因与病机的概括分析与说明。

本证《伤寒论》未载方。根据其“胃中虚冷”而见吐逆的病变特点，

可考虑用理中汤（见《太阴病篇》）加丁香、吴茱萸，以温中补虚，降逆止呕。

（13）吐后内烦证

太阳病本当发汗以解表而反用吐法，虽然吐亦能使气外达，而令人汗出，起到一定解表驱邪的作用，但吐后必伤胃中津液，津伤化燥，阴不和阳而虚热内生，故吐后表证虽解而不见恶寒，但接着而来的则是恶热、不欲近衣以及烦躁等津伤内热的证候发生。因虚热内扰，烦自内生，均由吐后所致，故《伤寒论》中说：“此为吐之内烦也。”

《医宗金鉴》为吐后内烦提出治法：吐后内生烦热，是为气液已伤之虚烦，非未经汗下之实烦也。唯宜用竹叶石膏汤，于益气生津中清热宁烦可也。

（14）肾阳虚水泛证

太阳病误以吐下的方法治疗，伤了中、上焦的阳气，可致水气冲逆而为病，是属苓桂术甘汤证，已如前述。若太阳病发汗太过，损伤了下焦肾阳，亦可因于阳虚不能制水而引起水泛为病。太阳与少阴为表里，太阳之气由少阴肾阳所化。过发太阳之汗，必内伤少阴肾中之阳，因而虽然发汗，但汗出病却不解。且由于少阴肾阳虚不能敛藏于内而外浮，故“其人仍发热”；阳虚水泛，上凌于心，故心下悸动；上蒙清阳，则头目眩晕；阳气者，柔则养筋，阳虚筋脉失养，则筋肉瞤动，肢体震颤，站立不稳而欲仆倒在地。治以真武汤温阳利水。

真武汤由茯苓、芍药、生姜、白术、炮附子组成。附子辛热，温经回阳以散寒水；辅以白术温运脾气，补土以制水；术、附合用，还可温煦经脉以除寒湿；茯苓淡渗，协白术以利水；生姜辛温，可温散水寒；芍药和血脉、缓筋急，且能制约附、姜之辛燥，使之温经散寒而不伤阴。本方用治肾阳虚水泛为病，与苓桂术甘汤不同，故方中用附子而不用桂枝。服大青龙汤，发汗太过，出现四肢厥逆、筋惕肉瞤等亡阳证，即可考虑用本方治疗。

曾治一司机李某，男，32岁。患头痛病，每在夜晚发作，疼痛剧烈，必以拳击头部始能缓解，或服用止痛片。问其起病原因，他说：夏天开车，因天气炎热，常在休息时痛饮冰镇汽水或啤酒，每日无间，至秋即觉头痛。问除头痛外，尚有何不适？答：两目视物常有黑花撩乱。

望其面色黧黑，舌质淡嫩、苔水滑，脉沉弦而缓。此阳虚水泛，浊阴上窜，清阳被蒙则眩，阴阳相争故头痛。为疏：附子12克、生姜12克、茯苓18克、白术9克、炙甘草6克、白芍9克、桂枝6克。服六剂，头痛大减。继服苓桂术甘汤四剂，巩固疗效而痊愈。

（15）肾阳虚烦躁证

“下之后，复发汗”，在治法上是一误再误。误下伤里阳，下后复汗则表阳亦伤。阳主昼，阴主夜，也就是白天阳气旺盛，夜晚阴气旺盛。汗下后阳虚之体能在白昼阳旺之时与邪抗争，故“昼日烦躁不得眠”；入夜阴盛，阳虚无力与邪交争，故“夜而安静”。阳虚阴盛，病入三阴，故不见少阳病的喜呕，阳明病的口渴，以及太阳病的头痛、脉浮等表证。脉沉主里，微主阳虚。“脉沉微，身无大热”而见微热，说明阳虚阴盛，格阳于外。证情危重，当急救回阳，用干姜附子汤。否则，贻误病机，恐一身脱汗而不可救。

干姜附子汤用干姜、附子大辛大热，以复脾肾之阳。附子生用，取其力更猛。与四逆汤比较，本方不用甘草之缓恋，有利于迅速发挥姜、附消阴回阳的作用。煎汤一次顿服，使药力集中，收效更快。

阴虚烦躁不得眠，以入夜为甚，与本证迥然不同，应从苔、脉加以鉴别。

（16）肾阴阳俱虚烦躁证

汗下不得当，不仅能伤阳，且由于津液的外泄，亦可导致阴伤。“发汗，若下之，病仍不解，烦躁者”，就反映了因汗下误治，使阴阳俱虚，水火阴阳不能相互交济，以致阳不得阴则烦，阴不得阳则躁。本证的烦躁不分昼夜，故与阳虚阴盛的干姜附子汤证有别，也不同于阴虚阳亢，虚热内扰的烦躁证。治疗用茯苓四逆汤，扶阳兼以救阴。

茯苓四逆汤由茯苓、人参、生附子、炙甘草、干姜组成。方用附子、干姜以温经回阳，用人参益气生津以救阴，茯苓益阴气而宁心养神，甘草和中。

（17）阴阳两虚与阴阳转化证

汗乃阳气蒸化津液而成，故发汗太过既可伤阳，又能伤阴。发汗后，表证解当不恶寒，若反见恶寒或恶寒更甚而振栗，说明发汗太过伤

了卫阳，而失于温煦所致。另一方面，由于津从汗泄，荣阴亦必随之而损。荣阴不足，筋脉失养，则见四肢挛急疼痛。阴阳两虚，所以脉见微细，治当扶阳益阴并施，用芍药甘草附子汤。芍药甘草附子汤用芍药以补荣阴，附子以补卫阳，炙甘草依附于阴阳之间，和中而兼顾。

若汗后，患者不恶寒只发热，说明表证虽解，但胃中津液已伤，津伤则化燥生热，而转为阳明胃家实证，故《伤寒论》中说：“发汗后……不恶寒，但热者，实也。”胃家实热，当见大便干结，治应泻下以和胃气，与调胃承气汤（方见《阳明病篇》）。

以上所述芍药甘草附子汤证和调胃承气汤证，说明同是发汗之后却有两种不同的结果，有从阴化寒者，亦有从阳化热者；有致虚者，亦有成实者；其所以有阴阳转化的不同，主要是因为患者机体有强弱之分，脏腑有寒热虚实之别，也就是说“病从类化”。

（18）随证施治

以上介绍了太阳病的各种变证及治疗，从中不难看出张仲景是始终贯彻“观其脉证，知犯何逆，随证治之”的辨证论治法则的。为了更好地指导人们在实践中运用这个法则，他在《伤寒论》中又举出随证施治的具体病例作为示范，以冀一隅三反。

“伤寒脉浮，自汗出，小便频，心烦，微恶寒，脚挛急”，说明太阳表证不解，而少阴之阴阳复虚。阳气虚，固摄、温煦的功能失职，故自汗、小便频数而微恶风寒；阴液不足，阳热上扰，筋脉失于濡养，故心烦，脚挛缩拘急。在里之阴阳皆虚，而外证又不解，自当正邪兼顾，用桂枝加附子汤，扶正以祛邪。若此时不顾患者少阴之里虚，“反与桂枝汤欲攻其表”，这是治疗的错误。服汤以后，必致阳愈虚不达四末，而四肢厥逆；阴愈伤不能上滋，而咽中干燥；阴阳俱虚，水火不相既济，而见烦躁吐逆。

这个病例的病情本来就较为复杂，又经误治之后，使病情更加复杂。对于复杂多变的病证，应分清标本缓急，进行有步骤的治疗。本病初起患伤寒，伤寒为病，重在伤阳，故在治疗时，亦当首先扶阳，用甘草干姜汤，使其阳生则阴长。待手足温，厥逆回，阳气复，再服芍药甘草汤以复其阴，阴液既复，则筋脉濡润，两脚挛急得以缓解而可以自由屈伸。如是则阳气能以温煦，阴液亦能濡养，即达到“阴阳自和”，则病必自愈。若在上述治疗过程中，由于人的体质差异而有寒热的变化，如服温药扶阳太过，以致胃热而见谵语、大便干结，则应“少与调胃承气汤”以泻下实热，使胃不燥而气自和，则谵语自止；若重复发汗，又加

以烧针劫汗，一逆再逆，一误再误，而其人阳气大伤，四肢厥逆更甚，此时再用甘草干姜汤以复阳也无能为力，应予四逆汤救治。

甘草干姜汤用炙甘草、干姜辛甘以化阳，重在扶中焦的阳气。脾主四肢，四肢为诸阳之本，中阳得复，则四肢厥逆自愈。用此方时，甘草剂量要重，应大于干姜用量的一倍以上，这样可以保证在扶阳的同时而无害于弱阴。

芍药甘草汤以芍药配甘草，酸甘化阴，和血柔筋缓急，善治两脚拘挛、筋脉拘急之病。

从以上病例可以看出，不管用什么治疗方法，或用热，或用寒，或用泻，或用补，都应该“见是证而用是方”，也就是一切从实际出发，以客观脉证作为施治的依据，而不能凭主观臆测。同时，也启示我们在处理复杂多变的病证时，要根据病情的轻重缓急做到治有先后，随机应变，照顾全面，不应该不分先后主次，墨守成规，顾此失彼。

举一个用芍药甘草汤的病例：李某，男，25岁。右腿鼠溪部生一肿物，形如鸡卵，表面不红，用针管抽不出内容物。右腿拘紧，伸而不能直，强伸则剧烈疼痛，足跟不能着地。每到夜晚，小腿经常抽筋，痛苦不堪。脉弦细而数，舌红而少苔。脉证合参，可知本证属阴血不濡，筋脉失养，挛而收引，故筋聚而成包块，腿难伸直，拘急转筋作痛。为疏：白芍24克，炙甘草12克。嘱服三剂，以观后效。患者见此方药仅两味，面带不信之色。虽勉强服药，但实少病愈信心。可是服药后，却效出意外，仅一剂而筋不抽痛，夜得安睡；进二剂，则鼠溪包块消退；服第四剂，足跟即能着地。

5.火逆的变证

关于火逆的变证，前面已做过一些介绍，主要讲的是火劫发汗而致伤阳的病变。这里讨论的是“因火为邪”，即火邪所引起的热盛伤阴以致动血阴伤的各种变证。

（1）太阳中风误火

太阳中风，本应以桂枝汤发汗以解肌，若误“以火劫发汗”，则不仅风邪不能解，且又加火邪为害，必伤其血气。气受热则动荡，血被火伤则流溢，气血沸腾，自必失其运行的常度。况风为阳邪，火亦阳热，风

火相扇，火助风威，风助火势，“两阳相熏灼”，溶其血液则身体发黄。阳热炽盛，迫血上行则欲衄；火热灼津，阴液虚竭则小便难。火劫发汗，不仅伤津，而且耗气，气血阴阳俱虚，身体失于濡润则枯燥。火热之气上蒸则头汗出，而颈项以下无汗。火灼津伤化燥，燥热内结，腑气不利，故见口干咽烂，腹满微喘，大便干结不通。若此时不抓紧治疗，拖延日久，则胃热盛发生谵语；胃阴大伤，失于和降，则生呃逆；若热极津枯，肾阴虚竭，水不济火，心神躁动，则可出现手足躁扰不安、捻衣摸床等阴竭昏糊的危候。其预后可以从小便的情况来判断：若其人小便先难后反利，反映了阴液尚未尽亡，生机尚在，故属“可治”；若小便已无，则是化源告绝，阴液消亡，而预后不良。

（2）伤寒阳郁误火

“脉浮热甚”，是表邪闭郁卫阳不得宣泄的太阳伤寒表实证，以发汗解表法治疗。若反用艾灸以温阳，即“实以虚治”，用治虚寒在里的方法来治表实阳郁之证，必致邪无出路，郁而化热，火热上炎，灼伤津液则咽喉干燥，灼伤阳络则吐血。

（3）表实内热误火

太阳病二日，表邪未解反见烦躁，说明或是素有内热，或是表不解而阳郁化热，形成表实里热证，此时应解表清里并施，不应用火来治。若“反熨其背（用瓦熨或用某种药物粉碎、炒热，布包敷于背部）而大汗出”，则必因汗出而致正虚，火邪乘虚入胃，胃中津液被劫，因而变生躁烦、谵语等阳明胃家实证。火逆而成阳明燥热胃家实，当用下法治疗。如果未经治疗，病至几日后，通过机体的自然恢复，使得津液渐充，火邪势衰，正气有力驱邪外出，亦可通过“战汗”或下利而使邪气外出作解。

（4）温病误火

“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病”。温病亦属太阳病之一，故其初起，形似伤寒。但由于伤寒是感受寒邪而表闭，故其脉弦紧，左右弹指有力；温病是感受温热邪气而津伤，故多见脉细弱而口渴。温病初起，邪在表，见发热、头痛、口渴、微恶风寒而脉浮弱者，当以辛凉解表，使之微汗出则愈；麻桂羌防等辛温燥烈劫阴之品，皆在所禁，当然更不能用火攻之法。若误用火劫，必助热伤阴，以致邪陷心包，而见

神昏谵语，甚则灼伤阴液，筋脉失养，热极动风，而见痉厥、抽搐等证。一次火逆误治，使病变坏，还尚可苟延时日；若一再误治，则患者将有生命危险。所以，《伤寒论》中特别告诫说：“一逆尚引日，再逆促命期。”

（5）阴虚误火

《伤寒论》中说的“微数之脉”，是指脉数而无力。“数脉为阳热可知”，但有虚热实热之分，数而有力者为实热，数而无力者属虚热，常见于阴虚不能制阳所发生的内热，治当滋阴和阳以清热，绝不能施以艾灸益阳劫阴以助热。若误用艾灸，必然“火上浇油”，成为烦逆之变。这种以驱逐寒实邪气的灸法，误用于阴虚火旺的患者，叫做“追虚逐实”。尽管艾火之邪不甚，但对阴虚之体来说，内攻也是有力的。本属阴虚筋骨失于滋润，再被火灼则阴血更耗，甚则肢体痿废，故为“焦骨伤筋，血难复也”。可见阴虚误火而致变的后果是相当严重的，一定要引起我们的特别警惕。

从以上诸火逆变证之多，可以推断在张仲景生活的时代，各种火疗的方法是相当盛行的，所用范围也很广泛。但由于火邪能助阳增热，伤阴动血，故用不得当，也会后患无穷。今世所用火疗方法已较古代差得多了，但附子、干姜、麻黄、桂枝等辛热药物，仍为临床所广泛应用，若触类引申，以彼例此，则温热病误用麻桂之弊，亦绝不可忽视。

（十）太阳病类证与治疗

太阳病类证，是指类似太阳病的证候。由于《伤寒论》中所讲的太阳病，主要是指风寒邪气客于肌表的证候，所以这里的太阳病类证，实际上指的是太阳病类伤寒证。

1.温病

温病亦属太阳病之一，故与太阳伤寒有相类似之处，但因其感受温热邪气，故又与伤寒不同。

六淫外邪，亦分阴阳。寒邪属阴，易伤人阳气，故其为病，太阳首当其冲；温邪属阳，伤人阴液，故其为病，太阴首当其冲。前者是足经受邪，后者为手经受邪。两经虽有手足之分，但其为病却不无联系，故太阳伤寒有太阴肺气不利的咳喘，而太阴温病亦见脉浮、头痛、恶寒等太阳病的证候。《灵枢·营卫生会》说：“太阴主内，太阳主外。”太阴，即手太阴；内，指营气；太阳，是足太阳；外，指卫气。营与卫在人体是对立的统一，其为病则互相影响，故仲景把伤寒与温病统称之为太阳病。然温病虽属太阳病，但又不同于伤寒。《伤寒论》中说：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。”就明确指出温病不待传经，即见口渴等热伤津液的证候，而与伤寒传里化热有别。病证不同，治法亦不同，温病当以辛凉解表而不能用辛温劫阴之药。

2.风温

风温在《伤寒论》中是作为温病误以辛温发汗而引起的坏证提出的，即“若发汗已，身灼热者，名风温”。其实，风温为病不仅来自温病误治，亦可由感受温邪与风邪，即风温合邪，共同侵袭人体而成。因温为阳邪，风亦为阳邪，风温合邪化热伤阴较一般温病更为迅速而且重笃，故风温病证见身热灼手，其热象亦较明显而突出。风温邪气客于表，故脉象同于太阳病而“阴阳俱浮”。风性开泄，热迫津液外泄，故自汗出；热盛伤气，气随津泄，故见身重；热盛神昏，故多眠嗜睡；风热

上熏，心肺不利，故鼻息必鼾而语言謇涩难出。此时若再误用攻下，必然更伤阴精，引邪内陷。阴液大伤，故小便困难而不利：精不上注于目，故两目直视；邪气内陷，心神被蒙，所以大小便不能控制而失禁。

3. 风寒湿痹证

痹者，闭也，闭塞不通之意。风寒湿三气杂合而至，经络受邪，关节筋脉不利，成为痹证。因其证以骨节疼痛为主，与太阳伤寒类同，故举出以作比较。

（1）桂枝附子汤证

风与湿合，侵袭人体，经脉气血阻滞，不通则痛，故见身体疼痛。其痛缠绵不已，酸楚难忍以致烦乱不宁，谓之“疼烦”。湿为阴邪，其性重滞，故身重疼痛，转侧翻身亦觉困难。湿邪难以速解，故伤寒八九日不愈。风湿在于肌表，无关少阳、阳明，所以病人不呕、不渴。浮脉是风袭，涩为湿阻，虚为卫阳不支，脉浮虚而涩是风湿伤卫。治以桂枝附子汤散风除湿，扶阳去寒。

桂枝附子汤由桂枝、炮附子、生姜、炙甘草、大枣组成。桂枝祛风通阳，附子扶阳以温寒湿，生姜散寒以走外，炙草、大枣养正以护内。

若其人大便硬而小便自利，说明湿重困脾，脾失健运，津液不能还于胃中。此证当以上方中去桂枝以免走散津液，加白术燥湿健脾引津液还于胃中，且白术配附子，可“并走皮内而逐水气”；若其人小便不利而大便不坚者，则还应加桂枝通阳助气化以行津液。

（2）甘草附子汤证

风寒湿邪杂合而至，寒湿留于关节，凝滞不解，筋脉不利，故骨节抽掣疼痛，不得屈伸，以手触按则疼痛更甚。因寒湿所困，表里阳气皆虚，故自汗、短气、恶风怕冷而不欲去衣。阳虚水湿不化，所以小便不利，肢体浮肿。治以甘草附子汤，温经扶阳以除风湿。

甘草附子汤由白术、桂枝、炮附子、炙甘草组成。方中桂枝、白术、附子并用，兼走表里以助阳化湿。本证湿留关节，邪入已深，不易速去，故治之宜缓。本方附子用量比前方为少，且以甘草名方，而使其作用缓恋持久，从而有利于表里之邪尽解。同时，在煎服法中要求每次

服药不应太多，也是不欲尽剂之意。

以上介绍的桂枝附子汤、去桂加白术汤以及甘草附子汤三个方证，都属阳虚风湿相搏证，其主要区别是：桂枝附子汤证重在卫阳虚而风湿在表，故桂附同用，温经通阳以散风湿；去桂加白术汤证，重在里阳虚而脾不转输，故去桂而术、附合用，健脾行湿以逐水气；甘草附子汤证是表里之阳皆虚，故术、桂、附并用，兼走表里，温经扶阳以缓除风湿。

四、辨阳明病脉证并治

阳明，指足阳明胃和手阳明大肠。两阳合明谓之阳明，说明阳明之阳气最盛。阳明为多气多血之经，邪客阳明，气血壅而容易化热，故阳明病属于外感热病中正邪斗争有力，热势亢盛的极期阶段。

形成阳明病的原因，有原发和继发两种。原发的阳明病，是邪气直犯阳明，在经之邪不解，随经入腑而成；继发的阳明病，多来自太阳之邪不解而内传，或由太阳、少阳病的汗不得法、误汗、吐下，伤了胃中津液所致。

阳明病在三阳病中属里证。由于阳明易从燥化，故其病变以燥热津伤，实热内结，以致腑气不通，而见痞、满、燥、坚、实的里实热证为主要特点。这种病证反映于外的证候，叫“阳明病外证”，以“身热，汗自出，不恶寒，反恶热”为主，并以此与太阳表证、少阳半表半里证相鉴别。

阳明病除腑证之外，还有经证、热证、寒证以及蓄血等，其病变重点在于腑实，故阳明病以“胃家实”作为辨证纲要。

阳明与太阴为表里，脾与胃相联系，若阳明病不从燥化，而是热与湿合，则湿热蕴郁，既不能外越以为汗，也不能下泄而从小便排出，湿热交蒸，还可以发生黄疸。

阳明病证候繁多，故其治法亦较复杂，或寒或温，或汗或下，均可随证使用。但由于其病变以腑实为主，故治法的重点在于泻下，正如尤在泾所说：“盖阳明以胃实为病之正，以攻下为法之的。”根据阳明病的上述证治特点，我们把阳明腑实证及其治法列在阳明病诸证之先，进而辨可下与不可下，然后再分别介绍经证、热证、寒证、蓄血证以及湿热发黄等诸证，从而使其重点突出，层次分明，便于学习掌握。

（一）阳明病辨证纲要

阳明胃与大肠，皆属于六腑。六腑的功能是传化物不藏，即饮食入胃则胃实，通过胃的腐熟和小肠的受盛化物，下移到大肠，则胃虚而肠实，在消化过程中只有始终保持这种虚实更替，才能使胃肠之气得以通顺，六腑的这种功能特点称为“以通为顺”。若胃肠燥热，津液干涸，糟粕结硬，大便阻于肠内不得排出，使肠实胃满，不能进行正常的虚实更替，以致上下不得通顺，阳明有实无虚，从而形成阳明病。

在三阳病中，太阳主表，阳明主里。阳明里证反映于外的证候，是为“阳明病外证”。阳明病外证，见身热，汗自出，不恶寒，反恶热，与太阳之表证有本质区别。太阳表证，虽有发热，但“必恶寒”；而阳明病属里实热证，故虽身热但并不恶寒，且因其里热炽盛，不仅不恶寒反而恶热。阳明里热蒸腾津液外泄，故汗出不断而量多，《伤寒论》中形容为“汗出濇濇然”，这与太阳中风仅表现为皮肤潮润的“**漐漐**汗出”有所不同。阳明热盛于里，气蒸于外，以致表里俱热，气血亢奋，所以脉见洪大。《伤寒论》中说：“伤寒三日，阳明脉大。”指出了太阳病到了三日要传经的时候，如果出现了洪大的脉象，说明病已传入阳明。

综上所述，可知“胃家实”是辨阳明病的纲领，身热、汗出、不恶寒、反恶热、脉大等证候，是判定为阳明病的主要依据。

（二）阳明病成因

阳明病有因受邪而直接发病的，如邪客阳明经，由经及腑，或胃肠积滞化热化燥等；但也有从他经传变而来的。例如：太阳病治不得法或误治，可以传变为阳明病。《伤寒论》中说：“太阳病，若发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳明。”就指这种情况。太阳病当发汗，但不能发汗太过，若过于发汗，或误用泻下、利小便的方法治疗，伤了津液，津伤则化燥，胃中干燥，大肠失润，腑气不通，以致大便秘结不下，因而转属阳明病。所谓“转属”，是病证转化但又未纯，具有并病之义。若一经证已尽解，完全进入到另一经，称为“转入”。如病邪已完全离开太阳，与太阳之表无关，纯入于阳明，即为太阳转入阳明。

太阳病发汗，汗出不彻或阳郁化热入里亦可转属阳明。太阳病感受寒邪，必使卫阳郁闭。若当汗不汗，或虽经发汗，但汗出不彻，均可由于卫阳闭郁不宣，寒邪从阳化热入里而成为阳明病。若证见“呕不能食”，说明病已内传及胃，以致胃失和降；若阳明里热已成，蒸腾、逼

迫津液外渗，可由伤寒无汗转为“反汗出濇濇然”，这些都是转属阳明的标志，也是我们进行辨证的主要依据。

由于阳明与太阴有着表里关系，阳明主燥，太阴主湿，燥与湿亦能相互转化，故阳明病与太阴病有内在联系，太阴病可以转化为阳明病。太阴脾主运化水湿，太阴病脾运失职，湿不能化而蕴郁，则“身当发黄”；若小便通利，湿从下泄，则不能发黄；至七八日见大便硬，说明湿已化燥，病已转属阳明。

（三）辨阳明病腑证并治

阳明腑证，又叫阳明腑实证，以“不更衣内实，大便难”为主要临床表现，它反映了胃肠实热内结、腑气不通的病理特点。“阳明之为病，胃家实是也”，这里的胃家实主要是指阳明腑证。

阳明腑实，当治以泻下。由于腑实证有轻重之分，因而治法方药亦有大小缓急之别。下面以三个承气汤证为主，分别介绍阳明腑证的各种辨证与治法。

1.调胃承气汤证

调胃承气汤证，是阳明病腑证的轻证或开始阶段，其病变重点在于胃中燥热成实而阳气有余，但大肠之燥热结聚尚属轻浅，故本证反映在大便上，还不能说已经成硬。调胃承气汤证的成因及证候表现有如下几种：

其病未经吐下，见不大便、心烦、躁动不安等证，说明此之心烦，非属栀子豉汤证的虚烦，而属于阳明病热实结于胃的实烦，当治以调胃承气汤。

或太阳病，发汗病不解，伤了胃中津液，邪气化热入里，里热外蒸而见“蒸蒸发热”，说明病已转属阳明。因为邪结不深，故并未出现其他的阳明里证，亦当用调胃承气汤治疗。

或太阳伤寒，不用汗法而反用吐法，吐后邪不外散，反因吐伤津液致邪陷阳明。邪热内结，胃肠之气不得通顺，见大便不通、腹胀满。然虽腹满但并不疼痛，说明邪结尚浅，大便亦未一定成硬，故也用调胃承

气汤治疗。

或太阳病不解，阳郁化热，过经（即传经）于阳明，阳明受邪，燥热内结熏于心，则见谵语，亦当用调胃承气汤下之。谵语为实，本当大便硬结，今不然，大便不仅不硬，反而下利，说明前医曾用过巴豆制成的丸药泻下。因巴豆属于热性泻下药，所以只能下大便而不能去其燥热，且有助热增燥的流弊，为此，虽大便下利，但谵语不解。一般地说，凡属虚寒性下利，则“脉当微厥”，今丸药泻下之后，脉不见微厥，依然同未下之前的脉象一样，即“脉调和者”，说明虽经泻下，但内实不去，谵语不解，还应以调胃承气汤治疗。

综上所述，可知调胃承气汤是治疗燥热初结，胃气不和而肠燥尚浅，见烦躁、蒸蒸发热、腹满、谵语等阳明实证。其证虽然也见大便秘结，但还没有到伤津劫液的地步，故调胃承气汤的作用以调和胃气为主，泻下则是次要的。陈修园说它为“法中之法”，也就是说它能在和胃之中又兼有泻下的双重作用。

调胃承气汤由大黄（酒洗）、甘草（炙）和芒硝组成。方中大黄苦寒泄热，芒硝咸寒软坚润燥，甘草甘缓和中，使大黄、芒硝缓恋于胃，从而变泄下为调和胃气。用本方有时要求“少少温服”，亦是为了不致大泻下，而达到和胃气的目的。

2.小承气汤证

小承气汤证，是属大便已经成硬的阳明腑实证，故比调胃承气汤证又深重一层。小承气汤证的形成有以下两种情况：

一是太阳病经汗、吐、下等法治疗，邪热入里，伤了津液，胃肠干燥失于濡润，故大便已成硬。胃肠燥热很盛，劫迫津液从小便偏渗，不能还于胃肠，故大便燥结，小便却反频数。当然小便越频数量多，则津液越伤，从而更增胃肠之燥，使大便更难解下。由于热结于内，上扰于心，故还可见到烦躁。

另一种情况是阳明病里热盛，逼津外渗则汗出多；汗出多则津愈伤，以致胃肠干燥则大便成硬。燥热不解，上熏于心，故见谵语。柯韵伯说：“多汗是胃燥之因，便难是谵语之根。”就指出了上述几个证候之间的因果关系。由于津液受伤而致燥热内结，大便成硬，即当用小承气汤泻下。

小承气汤由大黄（酒洗）、枳实（炙）、厚朴（炙）组成。方中大黄苦寒以泻下阳明燥热之结，厚朴苦温以除腹满，枳实苦寒以泄痞坚，朴、枳行气导滞下行，有助于大黄的泻下作用。本方泻下之力虽比调胃承气汤强，但仍较大承气汤为缓，故取名小承气汤。

3.大承气汤证

大承气汤证是比小承气汤证更为深重的阳明腑实证，它的病变特点是大肠燥屎已成，痞满燥坚实等证俱备，甚至还可见到燥热下伤肾阴的证候。《伤寒论》中有关大承气汤证的辨证内容很多，现综述于下。

阳明病燥屎内结，腑气不通，故可五六日甚至十余日不大便，并见腹满疼痛。燥屎结聚在结肠部位，所以绕脐疼痛。因腑实而致满，故燥屎不去，则“腹满不减”，或即使稍有缓解，亦是“减不足言”；燥热结于阳明之腑，故阳明气旺之时，正邪斗争有力，见“日晡潮热”；阳明主四末，四末为诸阳之本，阳明燥热内盛，迫汗外泄，故“手足濇然汗出”；阳明燥热攻冲而上扰心，可见“烦躁发作有时”，或“烦不解”，或“心中懊憹而烦”以致谵语妄言等证；胃热本当消谷能食，若燥屎阻滞大肠，肠实胃满，胃气不能通降，则其人“反不能食”；大肠与肺为表里，燥屎内结，大肠腑气不通，则肺气亦不能清肃下降而见喘满；腑气不行，影响血脉运行不利，故见脉迟，但脉实而有力。综上所述可知，若见腹满不能食，绕脐疼痛而拒按，日晡潮热，手足濇然汗出，烦躁，谵语，大便不通，脉迟而有力等证，说明阳明实热内盛，燥屎已成，当以大承气汤峻下。

大便燥结难下，是阳明病可下证的主要依据之一，但也不是绝对的，若患者因于阳明燥热津伤，而小便不利，燥屎内结大便困难，邪热内迫而又旁流时下，形成热结旁流，大便乍难乍易；燥热熏蒸于外则潮热，熏蒸于上则眩冒；腑气不通，影响肺气不利而见喘息不得卧，则也应以大承气汤治疗。

以上介绍的是当下而尚未攻下的大承气汤证，若已投大承气汤泻下，当时确也见功，继而又六七日不解大便，并复见腹满胀痛、烦躁不解等证，这是什么缘故呢？该不该再用大承气汤泻下呢？这是因为患者本有宿食积滞不消，虽经大下，但燥屎邪热未能尽除，而又复聚成实；或是大下之后，胃肠功能未复而又伤于食，宿食不化，胃肠之气阻滞，使腑气不通所致，此时仍应再用大承气汤泻下，务以积除热尽为度。

阳明腑证是邪热亢盛，津伤化燥的极期阶段，其病来势凶猛，变化迅速，若不及时采取果断措施以泻下燥热，“釜底抽薪”，则有涸竭阴液的危险，为此张仲景又提出以大承气汤急下存阴的阳明三急下证：

伤寒六七日，当是邪气传里之时。此时既无发热、恶寒的表证，又无潮热、谵语的里证，只见“大便难，身微热”，好像病情不重，但患者“目中不了了，睛不和”，也就是视物模糊，目睛不能转动，说明邪热深伏，阴精已被劫。《内经》说“五脏六腑之精气皆上注于目”，“热病目不明，热不已者，死”，可见“目中不了了，睛不和”，是为阴精欲竭的危象，当以大承气汤急下以存阴。

汗出本是阳明病外证，若“阳明病，发热汗多”，有不尽不已之势，亦当以大承气汤急下。为什么需要急下呢？程郊倩作了很好的说明：“发热而复汗多，阳气大蒸于外，虑阴液暴亡于中，虽无内实之兼证，宜急下之。”

阳明病属胃家实，由于胃肠之气不得通顺，故必见腹满胀痛之证，但其证多出现在大便硬结不下之后。如果不是这样，当太阳病发汗不解，病邪内并阳明之时，迅即出现腹满疼痛的实证，说明病势发展快，燥热津伤也较为厉害，以致不待时日循序而成，亦当用大承气汤急下燥热，夺其势而安其正。

从上述大承气汤的三急下证中，我们应该认识到燥热劫阴的严重性，并提示在遇到病势急，见有劫阴征兆的阳明燥热证时，就应当放手急下，而不应坐视徘徊。否则就会出现神昏不识人、循衣摸床、撮空理线、惊惕不安、微喘直视等热极阴伤，气液衰竭的严重后果。

大承气汤由大黄（酒洗）、厚朴（炙）、枳实（炙）、芒硝组成。方用大黄泻下热结，荡涤肠中燥屎；芒硝咸寒，软坚润燥，协大黄以泻下燥屎；厚朴理气除胀，枳实破气消痞，并相互配合以推动硝、黄的泻下作用。此方泄热破结，荡涤肠胃，攻逐六腑，其力甚大，故名为“大承气汤”。

调胃及大、小承气汤，均以承气取名，“承气”即承顺胃气下行之意。腑气不通顺在于胃肠实热内结，而三承气汤均有泻下实热以使腑气通顺、胃气下行的作用，故以承气名汤。

4.麻子仁丸证

阳明与太阴为表里，脏腑之气相通，脾为胃行其津液，燥湿相济，以维持阴阳平衡。若患者趺阳脉（即足背动脉，相当于足阳明经冲阳穴部位，常用以候脾胃之病）浮而涩，浮为阳气偏盛，涩是阴液偏衰，说明其病为阳明胃气强，太阴脾阴弱。以胃阳之强，加于脾阴之弱，使脾为之约束，而不能为胃行其津液，津液不能还入胃中，胃肠失润而干燥，则大便硬；胃气强，燥热逼迫津液偏渗而从小便下，故小便反数多。像这种胃强脾弱的证候，就不能再以承气汤泻下，当用麻子仁丸泻胃兼以滋脾。

麻子仁丸由大黄、炙枳实、炙厚朴、麻子仁、芍药、杏仁组成。方用大黄、厚朴、枳实（即小承气汤）以泻阳明胃气之强，用麻子仁润肠滋燥，杏仁润燥通幽，芍药养阴和血，蜜制为丸，取其缓缓润下之意。

曾治患者刘某，男，28岁。大便燥结，五六日一行。每次大便困难异常，往往因用力太过而汗出如雨。口唇发干，以舌津舐之则起厚皮如痂，撕则唇破血出。其脉沉滑，舌苔干黄，是属胃强脾弱之脾约证。因脾荣在唇，故脾阴不足，则唇燥干裂。为疏麻子仁丸一料，服之而愈。

5.蜜煎导法

阳明胃肠燥热而不大便，可用承气汤攻下；胃气强而脾阴弱的大便秘结，可用麻子仁丸润下。若阳明病，自汗出，本为津液外越，再用发汗的方法劫其津液，致使“津液内竭”，此时虽大便燥结坚硬，亦不能用攻下的方法以通其大便。因为津液既已内竭，再行攻下，必更伤津液，大便更加燥结不下。这种情况怎么办呢？要看患者想不想大便，如果患者不想大便，可以静静候之，待津液恢复，则大便可自下；若患者欲想大便而大便不下，其小便又数利而多，津液不能还入胃中以润燥，当用蜜煎导法。

蜜煎导法是用蜜放入铜器内，微火煎熬成饴糖状，俟其凝可成丸时，做成二寸长的蜜挺，趁热纳入肛门内，即可。若不用蜜煎导法，也可用土瓜根或大猪胆汁灌肠。《伤寒论》中土瓜根方已佚，猪胆汁灌肠法是取大猪胆一枚，泻出胆汁，加少量醋，灌肠，取其酸苦涌泄而又不致伤津。

（四）辨阳明病可下与不可下

下以去实，阳明腑实证用下法是为正治，但一定要运用得当。否则，不该下而下会伤害正气，促使邪气内陷，以致引发各种变证。因此，阳明病可下与不可下，就应该仔细辨别。

“太阳病，外证未解，不可下也”。阳明病从太阳病转来，虽因阳明里热外蒸而汗出多，但仍见发热恶寒，说明“外未解也”，不能用承气汤攻下；若见潮热、腹满而喘、汗出而不恶寒、脉迟，说明表证已解，“可攻里也”。阳明病不大便，并见汗出、谵语，而又恶风，说明既“有燥屎在胃中”，又有风邪在表，叫“表虚里实”，亦不当下；“过经”即太阳经证尽除而完全转入阳明，才可以用下法。若下之过早，则引起表邪内陷，更增阳明实热，发生语言错乱之证。

阳明病兼有少阳证亦不可攻下。阳明主里，少阳主半表半里。若阳明病见潮热，大便溏，小便正常，胸胁满不去，或阳明病不大便而呕，胁下硬满，舌苔白者，说明邪热未纯入胃，仍在半表半里少阳部位，此时只能用小柴胡汤（方见少阳病篇）和解表里，疏通三焦，使上焦得通而呕止，津液得下，胃气因和则大便自调，三焦通畅表里谐和，则濈然汗出而病解。少阳病喜呕，治应和解，汗、吐、下法均属少阳所禁用，故《伤寒论》中强调指出：“伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之。”

阳明病兼太阳表证不可下，兼少阳半表半里证也不可下，如上所述。若阳明病腹满微喘，既兼见少阳证口苦、咽干，又兼见太阳表证发热恶寒、脉浮而紧，当然也不能攻下；若不顾太阳、少阳证在，竟然攻下，必致邪气内陷，腹满更甚，津液损伤，故小便难。

病入阳明还有在经、在腑之分。在腑当下，在经亦不能用下法。“阳明病，面合色赤”，即阳明在经之邪不解，阳郁不伸而见满面通红，并无阳明里实热证的表现，就不能滥用攻下。否则，将损伤脾胃之气，使运化失职而生湿；在经之邪内陷而化热，湿热蕴郁熏蒸，可发生发热、小便不利以致黄疸等病变。

阳明病因于燥屎内结，腑气不通而致不能食，可用大承气汤攻下；但阳明病，若因于“胃中虚冷”，腐熟受纳失职，而不能食，就不能用攻下法。如果误以胃家实热而行攻下，必致胃气败坏而发生哕逆。

阳明病实热内结，大便成硬，腑气不通而致腹满痛者，才可攻下；

若阳明病，心下硬满而不痛，说明邪气结聚部位偏于上而又未成实，故“不可攻之”。若妄行攻下，必然使脾胃之气伤，邪气内陷，以致造成胃气败绝、下利不止的恶果，故《伤寒论》中说：“攻之利遂不止者死”。

阳明病大便硬，是可下的指征之一。而证见潮热、手足濇然汗出、小便数多则又是判断大便成硬的重要标志。所以“阳明病，脉迟……腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也；手足濇然汗出者，此大便已鞣也，大承气汤主之……其热不潮，未可与承气汤”。“阳明病，潮热，大便微鞣者，可与大承气汤；不鞣者，不可与之”，若其人“小便数者，大便必鞣”；“小便数，大便因鞣者，与小承气汤和之愈”。

阳明病大便确已成硬，燥热成实，方可攻下。若大便初硬后溏，热未结实，亦不能贸然攻下。若“初头鞣，后必溏，未定成鞣”而施以攻下，必伤脾胃之气而致运化不利，大便溏泄；若燥热确已成实，见小便通利，说明大便已经成硬，此时“乃可攻之”。

阳明腑实大便不通，当以承气汤攻下。但具体运用大、小承气汤时，又有攻下程度的不同。若见腹大满不通，脉滑而疾，说明里虽实满，但燥结不甚，则以“小承气汤微和胃气”，不能用大承气汤峻下；如见谵语、潮热、手足濇然汗出、腹满疼痛、脉迟而有力，说明燥屎已成，当用大承气汤泻下。判断燥屎形成与否，除观察潮热、手足汗出等证候外，还可先服小承气汤以测试。一般来说，服少量的小承气汤后，如果转矢气（放屁），则说明有燥屎，即可用大承气汤攻下；若不转矢气，且见大便初硬后溏，就不能再行攻下，不仅大承气汤不能用，就是小承气汤也不能用了。如果此时再误用下药，必然更伤脾胃之气，以致脾虚而发生腹胀满、不能食等证；更为甚者，不但不能食，就是饮水也要哕逆。所以《伤寒论》中再三强调“若不转气者，勿更与之”，“不转矢气者，慎不可攻也”。

（五）辨阳明病经证并治

阳明经证，是指风寒邪气初客阳明经表，尚未传入于腑的证候。

阳明经证的成因，有风寒之邪直客阳明经而形成的，也有因太阳病初得病时，汗出不彻，邪气不得外散，转属于阳明经而致的。

足阳明胃经行于身之前，从鼻面而下走于胸腹。风寒邪气客于阳明

经脉，则经气怫郁，阳气不伸，因而见缘缘面赤（满面通红）、额头作痛、发热恶寒、无汗、目疼鼻干、睡卧不宁、脉浮长或浮大、舌苔薄白等证，治当疏解阳明经表之邪，用葛根汤微发其汗。若阳明病不大便、脉迟、汗出、潮热而不恶寒者，说明表解而里实已成，当以承气汤下之；如果汗出虽多，脉迟缓，不见潮热仍有微恶风寒的，说明阳明经表之邪犹未尽解，因其有汗，故可治以桂枝汤解肌疏风；若阳明病，见脉浮、无汗而喘的，是风寒邪气客于阳明经表，表实外闭，肺气不宣所致，应以麻黄汤解表发汗，宣肺平喘，切不可见其不大便而先攻下。

太阳病脉浮紧，是为风寒表实，而阳明病不大便，脉见浮紧，说明邪气一半在表一半入里，因为脉紧主阳明里实，脉浮则主经表有邪。只要有阳明里实存在，就必然出现潮热，发作有定时；若无里实存在，脉但浮而不紧，说明邪气在阳明之经，不在阳明之腑，仍当发汗则愈。由于在经之邪稽留不解，久而化热，邪热伤阴，可使人发生盗汗。或阳明在经之邪不解，但又未入于腑，经热而腑不热，故见口干燥，但欲漱水不欲咽，治疗亦当疏解阳明经邪。若治疗不及时，或在经邪热太甚，波及血分，则可发生衄血之证。同样道理，阳明经邪不解，热在经而不在里，故见“脉浮，发热，口干鼻燥”；因无损于胃肠功能，故“能食”；经热不解，灼伤阳络，亦可发生衄血。有的注家认为衄血是由于热在血分，此说有一定道理，可供参考。

“阳明病，法多汗”。若“阳明病，反无汗”，而二便亦通利，说明里无邪扰，只是风寒邪气客于阳明之经而已。如果经证不解，因循二三日，当汗不汗，邪气闭郁而影响肺、胃之气不利而上逆，则可出现呕而咳逆等证；更为甚者，经邪闭郁，阳气不伸，经气不利，还可见手足厥逆、头痛等证。若患者不咳、不呕、手足亦不厥逆，说明经表之邪闭郁不甚，因而头也不痛。

（六）辨阳明病热证并治

阳明热证，是指阳明里热炽盛，但尚未敛结成实，热在气分而弥漫全身，充斥内外，表现为表里俱热的一种证候。阳明热证与阳明腑证比较，腑证可以说是有形之里实，而热证则是无形之里热。因热证之身热来自于里热，并非邪在经表，故也不同于阳明经证。

阳明里热，弥漫全身，充斥内外，故一身表里皆热；热盛迫津外泄，故汗出；热盛津伤，故口燥舌干，烦渴而喜冷饮；阳明热甚，气血

沸腾，故脉洪大或浮滑而数。上述所举大热、大汗、大渴、脉洪大，即“四大证”，可以说是阳明热证的典型证候，也是阳明热证的辨证要点。治疗应当清热生津，用白虎汤。《伤寒论》中所说：“伤寒，脉浮滑，此表有热，里有寒，白虎汤主之。”就是以脉断证并为阳明热证出其治法。伤寒脉浮滑，浮是热盛于外而表热，滑是阳盛于内而里热，表里俱热，说明太阳表邪已化热转属阳明。条文中“里有寒”的“寒”字，应作“邪”字解，具体说就是邪热在里，邪热内炽，阳气亢盛，若能以透发于外，则表里一身皆热；如果不能透发于外，达于四末，可见身大热而手足反厥冷。由于这种手足厥冷，是阳热盛于内而格阴于外，阴阳气不相顺接所致，故称为“阳厥”或“热厥”。“伤寒，脉滑而厥，里有热”，就指这种证候，也当以白虎汤治疗。

白虎汤由石膏、知母、粳米、炙甘草组成。方中石膏大寒，善清阳明气分之热而不伤津；知母苦寒而润，既能清热又能滋肺胃之阴；粳米、甘草滋养胃腑气液。四药合用，共奏清热生津之功。服白虎汤，邪热得清，阳气无阻而畅达于外，则手足厥逆自解。

若白虎汤证，“热结在里，表里俱热”，表现口干舌燥、烦渴特甚，以致“欲饮水数升”，并更见“时时恶风”、“背微恶寒者”，说明大热所及，不仅伤津，而且耗气。阴津大伤无以滋润，故口舌干燥，烦渴不解；阳气受损，无以卫外，故时时恶风，背微恶寒；热盛而气液不足，故脉洪大而芤。此时单用白虎汤清热就不足用了，应加人参以益气生津。

白虎汤虽为清热之剂，但只为阳明而设，若见“伤寒脉浮，发热无汗”的太阳表证，不见烦渴等阳明里热证，或虽见烦渴等阳明里热证，但太阳表证不解者，均“不可与白虎汤”。因为太阳表证，是卫阳闭郁所致，当用发汗之法以解阳郁之热，若误用白虎汤，或过早投入寒凉药物，则会冰伏表邪，郁遏阳气，促使邪气内传而发生种种变证。因此，用白虎汤，必以热入气分而无表证者为准。

举一个病例：刘某，女，5岁。感冒三日而热不退，体温40℃，周身出汗，而热不为汗减，烦渴欲饮，唇口干燥，脉洪大而舌苔黄。此证热在气分，内薄阳明，迫汗外出，而烦渴引饮。然大便不燥，胃虽热但不实，故可清而不可下。为疏：生石膏30克，知母9克，炙甘草6克，粳米一大撮。

服二剂，热退汗敛而病愈。

（七）辨阳明病寒证并治

阳明病，虽以胃家实热为主，但亦涉及虚寒证，因六经辨证，不只是为伤寒而设，而且还包括许多杂病内容，其证涉及虚实寒热各个方面。

阳明病的虚寒证，是由于胃阳不足，寒从内生，受纳腐熟水谷无权，证见不能食。《伤寒论》中的“阳明病，若不能食者，名中寒”，即指此证而言。脾胃虚寒，中气不运，水谷精微不能正常化生与输布，因而不仅不能食，而且由于水湿内停，还可见小便不利。由于阴寒内盛，阳气不固而外泄，四肢稟气于胃，故可见手足濇然汗出。中阳不足，温运失职，胃肠寒气凝聚，可形成大便初硬后溏的“固瘕”。阳明病虚寒证，可见不能食、小便不利、手足濇然汗出，有似阳明胃家实证，但胃家实必大便燥结难下，而阳明虚寒则是大便初硬后溏，两证截然不同。

中焦阳虚，寒湿内生，还可发生黄疸。阳明病胃气虚寒，则脉迟无力，食难用饱，若饱食则胃气无力消磨，以致水谷不化，填滞中焦发生腹胀满；食郁于中，则微烦；清阳不升，则头目眩晕；水湿不能温运以下泄，故小便困难。若不及时治疗，必将使水谷不消，寒湿内蕴而发为谷疸。瘕同于疸，“谷疸”亦属黄疸病之一，因其发病与饮食不化有关，故名。这里的谷疸是因于寒湿所致，故治当温化，若误认为是湿热蕴郁而投以寒凉泻下，必更伤脾胃之气，不但黄疸不除，而且腹满仍然如故。

上述两证，一个见不能食、小便不利、手足濇然汗出、大便初硬后溏而欲作固瘕，属于胃寒似燥；一个见脉迟、食难用饱、小便难而欲作谷疸，属于胃寒似热，从而在主论阳明燥热成实的同时，兼述阳明胃气之虚寒，则有热有寒，有实有虚，有燥有湿，一一对比，层层分析，极尽辨证之能事。

若阳明病胃气虚寒，必不能受纳腐熟水谷以下行，胃失和降而逆于上，故“食谷欲呕”。食谷欲呕，是形容进食欲纳而又不能纳的一种证候表现，由胃气虚寒所致，故“属阳明也”。治以吴茱萸汤温胃散寒，降逆止呕。

吴茱萸汤由吴茱萸、人参、生姜、大枣组成。吴茱萸味苦而辛，能下气暖肝胃以治寒；佐以生姜温胃散寒以消饮；人参、大枣甘温补中，益气扶虚。若服吴茱萸汤，其人呕吐反而更为厉害的，说明中焦虽有寒，但膈上还有热，吴茱萸汤只能温中寒不能清上热，反有助上热之

弊，故“得汤反剧”。胃中有寒，膈上有热，当寒热并用，可考虑用黄连汤。

曾治闫某，男，37岁。患十二指肠球部溃疡已一年有余，某医院外科建议手术治疗。其病发作，常于每夜12时左右，见左下腹胀痛，呕吐反酸，周身寒战，头目眩晕。察脉弦缓，舌质淡嫩，苔白而润。从舌脉看，反映了肝胃寒邪上逆之象。子夜为阴盛之极，故病发胀痛、呕吐；阴来搏阳，故寒战。为疏吴茱萸汤：

吴茱萸12克，生姜12克，党参9克，大枣12枚。

服二剂，诸证皆减，唯大便干，原方加当归9克，服十二剂，病愈。

（八）辨阳明病蓄血证并治

阳明蓄血，是血蓄在胃肠，故见大便虽硬反易，与太阳蓄血见少腹急结者不同。“血主濡之”，阳明蓄血在肠，因有血之濡润，故其人“屎虽鞭，大便反易”，色如黑漆，与阳明胃家实大便硬、燥屎难下者不同。阳明蓄血是由于离经之血不能及时排出，从而形成“久瘀血”。瘀血与热相结，上熏于心，则神识不聪，故其人喜忘。喜忘，即善忘，指应酬答对失常，语言动静随过随忘。阳明蓄血亦当以抵当汤攻逐瘀血。

若病人无头痛、恶寒之表证，亦未全备可下之里证，唯有发热至七八日不解，当考虑热结在里，此时脉虽浮数，亦不可发汗；若其人不大便，亦可用承气汤攻下。假如已下，脉不浮而数不解，说明阳明气分之热已除，血分之热未解。这里的血热，是阳明的久瘀而又与热结，故有“合热则消谷善饥”的证候，与腑实燥结之不能食不同；热灼津伤，则大便硬而不下；瘀血濡润，故大便色漆黑而反易，也与阳明腑实大便燥结难下有别，瘀血与热内结于阳明的，治宜抵当汤。若上述脉数不解，大便不成硬而是下利不止，则属协热利，由于热灼阴络，腐败成脓，终必有大便脓血之患。以上同是下后，见脉数不解，但一个内有瘀血不大便，另一个是协热下利便脓血，其证不同，治亦不同，前证可用抵当汤，后证就不能再用抵当汤。

（九）湿热发黄证治

阳明病热盛津伤而从燥化，则大便秘结不通而成胃家实证；若阳明病津液未伤，热与湿合从湿化，则小便不利而成湿热发黄。

阳明病由于内热蒸腾，见发热、汗出、小便数多，热与津液能以外越，无湿热蕴郁，故“不能发黄”；若虽有里热而被湿引，不能迫使津液外渗，因而不得汗出或只是头上出汗，颈项以下无汗；湿被热引则小便不利；湿热不能外出，热郁于里，则渴引水浆，心烦懊^怏；湿阻于内，故腹微满；湿热蕴结，胆液疏泄不利，则可发为黄疸。因湿热发黄，其色鲜明如橘子色，故称为“阳黄”，治以茵陈蒿汤。

茵陈蒿汤由茵陈、栀子、大黄组成。方用茵陈清热利胆以退黄，大黄泄热导滞，栀子清利三焦湿热。三药合用，可使瘀热湿浊从小便排出，故《伤寒论》中说服药后：“小便当利，尿如皂莢汁状，色正赤。一宿腹减，黄从小便去也”。本方在临床上用治多种肝胆疾患所引起的黄疸，只要是属于阳黄者，均有效。若兼见胁肋胀满或疼痛的，可加柴胡、黄芩；呕恶者，加半夏、生姜；两足发热，加知母、黄柏。

曾治刘某，男，14岁。春节间食荤腥，又感外邪，始则发热恶寒，不欲饮食，小便黄赤，心中发烦，继则全身面目皆黄染，体疲无力，懒动懒言。脉弦而滑数，舌苔黄腻。此证为外感邪热与内湿相合，蕴郁不解而为黄疸。

为疏：茵陈30克，大黄9克，山栀9克，凤尾草9克，土茯苓12克，草河车9克。

此方加减进退，共服八剂，黄疸退。

若病黄疸，湿热相蒸而里未实，身虽热而腹不胀满，或者用茵陈蒿汤以后余热未尽，其人尿黄、心烦，属湿热郁于三焦不解的，可用栀子柏皮汤治疗。栀子柏皮汤由栀子、黄柏、炙甘草组成。栀子泄三焦郁热从小便出，黄柏清热燥湿，甘草和中健脾，且制苦寒伤胃。根据临床经验，本方用治肝炎的黄疸，与茵陈蒿汤交替使用，常能收到较满意的疗效。

湿热发黄，也有因于表邪不解，汗不得出而瘀热在里，与湿相合，蕴蒸而成为黄疸的，必见脉浮、发热、恶寒等表证，治以麻黄连轺赤小豆汤，外解散在表之邪，内清利湿热之郁。麻黄连轺赤小豆汤由麻黄、连轺、杏仁、赤小豆、大枣、生梓白皮、生姜、炙甘草组成。因有表邪，汗不得出，而瘀热在里，故用麻黄、杏仁、生姜宣肺以发表；湿与热合而为黄疸，故以赤小豆、连轺、梓白皮清利湿热；大枣、甘草甘温悦脾，健脾和中，扶正以驱邪。方中连轺，原为连翘根，今多以连翘

代，梓白皮有一定的催吐作用，应慎用，现常以桑白皮代。

以上所述治黄疸之三方，就其作用来讲，茵陈蒿汤是泻热，梔子柏皮汤是清热，麻黄连轺赤小豆汤是散热，临证时当审其病位所宜而选用。

（十）阳明病的预后

阳明病主要是实热阳证，虽然邪气实但正气亦盛，故治疗得当，一般预后良好，极少死亡。但如果治不及时，或治疗不当，以致邪实正虚，也会出现气脱、阴竭等险证，甚至死亡。有关阳明病的预后，在前边可下与不可下的辨证中，亦有所涉及，这里就不再重复了。下面再补充几个例证。

阳明病，外邪初传于胃而化热，热则消谷故欲食；如果邪热结聚成实而化燥，则小便数多而大便当硬，今小便反不利而大便自调，说明湿热内蕴而不成实；湿流关节，筋脉不利，故骨节疼痛；湿热蕴郁熏蒸，则“翕翕如有热状”。热能消谷而欲食，反映了其人阳气旺盛；水谷进则正气充，正气充盛就能驱邪外出，湿热邪气得以外越，则患者可忽然见狂躁、濈然汗出而病愈。《伤寒论》在解释本证的自愈机制时指出：“此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。”这里的脉紧，有的注家认为是脾胃之气旺盛的表现，脾胃气盛能驱湿热与汗共并而出，故病愈。

阳明病有实有虚，故其证可见谵语与郑声。谵语，是患者在神识不清情况下的胡言乱语，语无伦次，声长而壮，是热盛神昏的一种表现，属于实证；郑声也是神识昏迷状态下的一种胡言乱语，其特点是语言重复，声音短而细微，常见于心气内损，精神散乱的危重阶段，属于虚证。若阳明病见直视谵语，主燥热盛而阴精伤，精不灌目，目系急而不转；如在前证基础上更见喘满的，说明阴气竭、阳气亦无所依附而脱于上；如不见喘满而见下利，则是脾气不收，气陷于下，这两种情况预后均不好，故《伤寒论》中说：“喘满者死，下利者亦死。”

本太阳病，发汗过多，因而转属阳明，若再重发汗，不仅竭其阴，而且亡其阳。胃中燥实不除，故神昏谵语；若脉见滑而有力，或长大而盛者，为脉证相符，病虽甚而不死；若见脉短，是为邪热盛而正气衰，阳证见阴脉，其预后多不良。

五、辨少阳病脉证并治

少阳属胆与三焦，与手足厥阴相为表里。少阳虽亦属三阳之一，但其抗邪能力不如太阳、阳明。太阳主表，阳明主里，少阳主半表半里。太阳经行于背，阳明经行于腹，少阳经脉行于身侧，居于太阳、阳明两经之间，外则从太阳之开，内则从阳明之合，从而起到枢机的作用，故《素问·阴阳离合论》说：“少阳为枢。”

少阳病可从他经传来，也可由本经起病。由于邪气结在胁下少阳胆经部位，正邪斗争于表里之间，故表现为往来寒热、胸胁苦满、口苦、咽干、目眩等证候。

太阳病邪在表宜汗，阳明病邪在里宜下，少阳病邪在表里之间，故汗下皆在所禁忌，当以小柴胡汤和解为正治之法。至于少阳的各种兼夹证，则另有相应的权变治法。

（一）少阳病辨证纲要

少阳胆与三焦，内寓相火。胆附于肝，其性主疏泄。三焦为气机通行的道路。少阳受邪，气郁不疏而化火，胆火循经上炎，则见口苦；灼伤津液，故咽喉干燥；肝开窍于目，少阳、厥阴风阳上扰，故目眩。因少阳病以疏泄不利、风火内动为其病变特点，以口苦、咽干、目眩为主要临床表现，所以《伤寒论》以“少阳之为病，口苦，咽干，目眩也”作为少阳病的辨证纲要。

（二）少阳病的正治法

太阳病伤寒或中风经过五六日，若见“往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕”等证，是为邪传少阳。

病邪结于少阳胁下部位，正邪分争在表里阴阳之间，邪气进而入阴则恶寒，正气胜抗邪出于阳则发热。由于邪有进退，正有胜负，故患者时而发热时而恶寒，寒来热往，热来寒往，寒热交替出现，即为往来寒热。少阳经脉从缺盆下腋，循胸过季肋，受邪则经气不利，郁而不舒，故见胸胁满闷；少阳气郁，疏泄失职，则精神沉默抑郁，郁而化火则见烦躁起急；“邪在胆，逆在胃”，少阳受邪，疏泄不利，进而影响脾胃消化功能，则不欲饮食，甚或胃气上逆而频频作呕。又因少阳居半表半里部位，其气有乍进乍退之机，故其病情亦变化多端，表现有许多或见之证：如热郁于胸中而不及于胃，则胸中发烦而不呕；若邪热耗伤津气，则口渴；若气机不舒而血脉不利，故见腹中痛；邪气结聚而及于肝，故胁下痞硬而有形；三焦水道不通利，水饮内停而上凌，故心下悸，小便不利；若邪偏于表，故口不渴，身有微热；邪气犯于上，肺气不利，则见咳嗽。在少阳病上述诸证候中，往来寒热既不同于邪在太阳之发热恶寒，也不同于邪入阳明之但热不寒；而胸胁苦满，也反映了少阳证不同于太阳病的头项强痛和阳明病的腹中胀满，因而往来寒热和胸胁苦满这两个证候，对诊断少阳病有典型意义。少阳病治疗，当以和解之法，用小柴胡汤。

小柴胡汤由柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、炙甘草、大枣组成。柴胡配黄芩，以清少阳经腑之热，并疏泄肝胆之气郁；半夏配生姜，能散能降，外散其结，内降其呕；人参、甘草、大枣甘温补脾，助正祛邪，以防邪传太阴。此方能升能降，能开能合，祛邪而又扶正。因其不经汗、下手段，而以清透疏通作用达到祛除病邪的目的，故将这种治法称为“和解”法。若其人心胸发烦而不呕，为痰热蕴于胸，当去人参之补、半夏之燥，加瓜蒌实清热去痰开结；口渴者，为邪热损伤津气，故去半夏之燥，加用人参的剂量，协同瓜蒌根以益气液之不足；腹中痛，是肝脾不和，木郁乘脾，血脉不利，故去黄芩之苦寒，加芍药以平肝、和血脉而止腹痛；胁下痞硬，为邪气结聚而坚凝，故去大枣之甘缓，加牡蛎咸寒以软坚消痞；心下悸、小便不利，为水邪内停，气化不行，故去黄芩之寒凝，加茯苓淡渗以利水；外有微热而口不渴，为表邪未解，故去人参之补，加桂枝以解表邪；咳者，是寒邪客肺为病，当去人参、大枣之滞气，易生姜为干姜，再加五味子以温肺散寒。

《素问·评热病论》说：“邪之所凑，其气必虚。”这一论点在少阳发病过程中得到了很好的体现。《伤寒论》中说：“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。”指出当人体气血虚弱时，腠理不固，正气无力抗邪，邪气侵入，直接结于胁下，发为少阳病。由于正邪交争，故表现为往来寒热，发作与休止有一定的时间；肝胆气郁，

则神情默默而不欲饮食；由于脏腑通过经脉的络属而相连，因此脏腑为病也要相互影响，随着邪气的深入，疾病也要从腑入脏，向更深一层发展：邪从外来其位高，病在于里叫“痛下”，正气拒邪于上，必上逆而作呕。如《伤寒论》中所说：“正邪分争，往来寒热，休作有时，嘿嘿不欲饮食，脏腑相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也。”就是对上述少阳病证病变机制的精辟分析。

若本为太阳病，而邪气内传少阳，则见胁下硬满而痛，干呕不能食和往来寒热，此时，如未经吐下等误治，其脉沉弦而紧的，说明邪气已全部离开太阳转入少阳，治疗当以小柴胡汤和解；若上述证情已经吐、下、发汗、温针等治法，而柴胡证已罢，却见谵语，这是属于正伤邪留所致的坏病，当仔细审察病因、脉证，“知犯何逆，以法治之”。因此，不能再用小柴胡汤了；若虽经误治，但柴胡证仍在的，说明病位、病机没有改变，仍可复与柴胡汤和解，但由于是误治正伤之后再进柴胡汤，正气得药力的帮助，奋起抗邪，驱邪外出，因而“必蒸蒸而振，却发热汗出而解”。关于战汗作解，临床上可见于以下几种情况：有误治后而正气仍能抗邪于外，见战汗病解的；有邪陷于里，而正气复能拒邪外出，见战汗而解的；亦有服药之后，或借助于饮食，使正气得助而拒邪外出见战汗作解的。临证时当具体分析，区别对待。

由于小柴胡汤能和解少阳半表半里之邪，故它还能治疗阳微结的病证。“阳微结”是指阳热之邪微结，其证候表现是既有头汗出，微恶寒的表证，又有手足冷、心下满、口不欲食、脉沉细而大便硬的里证。大便硬为阳结，主邪热传于里，然以外带表邪，则邪结犹浅，故谓阳微结。脉沉虽为在里，但也不能误认为是纯阴结。“纯阴结”是指少阴阴寒的凝结，纯属里证，不见表证。因为“阴不得有汗”，即病在阴经均不见汗出，而此证却有汗出，故虽见脉沉紧，亦不能断为少阴病，而属于“半在里半在外”的病证，亦当用小柴胡汤和解表里。若服小柴胡汤后，表邪解而里气未和，其病尚不了了，可微通大便，使之“得屎而解”。

伤寒脉弦，为邪传少阳之征。若脉浮取涩滞，沉取弦劲，是脾虚而肝胆气郁的表现。脾虚肝郁，以致气血不能流畅，故见腹中急痛。根据“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”的治疗法则，可先以小建中汤缓中补虚以止痛；如果服药后，而腹痛仍不见好的，则还要以小柴胡汤疏利肝胆，其病可愈。

若少阳病外兼太阳之表，内兼阳明之里，半表半里枢机不利而兼表里不和，亦应以小柴胡汤和解。如太阳伤寒，病已四五日，证见身热、恶风、颈项强，是太阳之邪未解；又见胁下满、手足温而渴，说明邪热不独在太阳，而且已浮泛于少阳、阳明二经。三阳经证俱见，当治在少

阳，少阳枢机一利，则三阳之邪均可相应而解。本证可用小柴胡汤去半夏，加瓜蒌根、牡蛎以和解表里，生津滋液。

下面举许叔微治疗的两个病例说明小柴胡汤的用法。

“董齐贤病伤寒数日，两胁挟脐痛不可忍，或作奔豚治。予视之曰：非也。少阳胆经，循胁入耳，邪在此经，故病心烦、喜呕、渴、往来寒热、默不能食、胸胁满闷，少阳证也。始太阳传入此经，故有是证。仲景云：太阳病不解，传入少阳，胁下满干呕者，小柴胡汤主之。三投而痛止，续得汗解。”（引自《伤寒九十论》）

“有人患伤寒五六日，头汗出，自颈以下无汗，手足冷，心下痞闷，大便秘结，或见四肢冷，又汗出满闷，以为阴证。予诊其脉沉而紧。予曰：此证诚可疑，然大便秘结，非虚结也，安得为阴？脉虽沉紧，为少阴证，多是自利，未有秘结者，予谓此正半在里半在表，投以小柴胡得愈。”（引自《普济本事方》）

小柴胡汤是治疗少阳病的主方，本节介绍的少阳病正治法，即小柴胡汤的应用。从上所述，可以看出小柴胡汤证的见证甚多，但在临床运用时，也不必等诸证俱备才能用，只要见往来寒热、胸胁苦满等一两个主证即可投以小柴胡汤，所以《伤寒论》中提出：“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。”

（三）少阳病治疗禁忌

邪在表，当发汗以祛邪；邪在里，当泻下以去实；邪在少阳，非表非里，属于半表半里，只能用小柴胡汤和解表里，而汗、下之法皆在所禁忌。邪在上者，“因而越之”，当用吐法，而少阳之邪在表里之间，故吐法亦不能用。再者，少阳病无论经证还是腑证，都应治以和解之法，用小柴胡汤，这和阳明经证可汗、腑证可下的治法亦不相同。

如少阳病见耳聋、目赤、胸满而烦等证，是属邪热客于少阳经脉为病。少阳胆经起于头目，环绕于耳前后，入胸中。邪热循经上扰，经气不利，故见耳聋、目赤、胸满而烦等证，当治以小柴胡汤和解少阳在经之邪，不能用吐、下的方法治疗。若误治以吐下，必耗伤气血，导致心虚而悸，胆虚而惊。

头痛发热见浮脉，是病在太阳，为表证不解，当发汗解表；若脉不见浮而见弦细，说明病已转属少阳，因“少阳不可发汗”，故不能再发

汗的治疗方法，应该用小柴胡汤和解。少阳为病，内有邪热，若解表发汗不仅无益于少阳，而且会助热伤津，津伤化燥，邪陷于胃可发生谵语。如果其人津液能自然恢复，使胃中阴阳自和的，则谵语亦可不治自愈；如果胃中津液不能自和，燥热邪气不解，不但谵语不愈，而且要导致邪实正虚，更见心烦、心悸等证。

以上介绍了少阳病禁汗、禁吐、禁下，以及汗、吐、下后引起的变证。根据临床观察，凡少阳病误治之后，若其人能食而胃气不败的，预后多好；若水浆不入，胃气已败，预后多不良。

（四）少阳病机进退

少阳不但居于表里之间，而又位于阳经之末，阴经之始，故凡邪气出入进退，如表邪入里，或阳邪入阴，莫不与少阳有关。少阳主枢，除主表里之枢外，亦主阴阳之枢。

少阳主枢，具体反映在脏腑经络病变的相互影响上。“邪在胆，逆在胃”，即指出少阳病必然要影响脾胃的功能；而脾胃功能是否健全，又是判断表邪是否入里，阳病是否转阴的重要标志之一。如《伤寒论》中说：“伤寒六七日不解，无大热”，反映了表邪入里；而“其人躁烦”，则标志着邪聚阳明，将形成胃家实热证。在表之邪所以能内传阳明，即“阳去入阴”，实与少阳枢机不利，不能透达表里之邪有关。正因为少阳枢机具有疏通、调节表里内外的作用，所以当三阳合病，脉见浮大，上关上（浮为太阳之脉，大为阳明之脉，关上是为少阳所属部位）；三阳热盛，热壅神气而使人“但欲眠睡”；阳盛迫阴，故见睡则汗出等证时，既不能汗解，也不能用下法，唯有用小柴胡汤和解以利枢利，枢机利，表里之邪得以透达，其病自愈。这就是三阳合病，治在少阳的道理所在。

少阳枢机不利，不仅可使表邪入里而内传阳明，亦可使病证由阳转阴，进一步发展成为三阴病。但能否传入三阴，也要看患者脾胃功能是否旺盛。若“伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪，其人反能食而不呕”，说明脾胃功能尚好。太阴脾为三阴之屏障，能食而不呕，反映了太阴脾气健旺，太阴不病则少阴、厥阴亦不会发病，故谓“三阴不受邪也”。如果此时其脉由大变小，说明邪气亦衰，疾病向好的方面发展，所以说为“欲已也”。

（五）少阳病权变治法

少阳病禁汗、禁下，宜以和解之法治疗，此言其常；但少阳病又有兼太阳、阳明等证，故又有可汗、可下等权变治法，现分述如下。

1.柴胡桂枝汤证

伤寒六七日，病处传变之时，若仍见发热、微恶寒、四肢关节疼痛而烦，说明邪在表而“外证未去”；同时，又见恶心欲呕、心下或连及两胁满胀堵闷，反映邪已向里发展而入少阳。先病太阳，又并少阳，而太少之邪俱不甚，故治以柴胡桂枝汤两解太少之邪，以和枢机。

柴胡桂枝汤由柴胡、桂枝、芍药、黄芩、人参、甘草、半夏、生姜、大枣组成。本方即柴胡桂枝各半汤，为太阳、少阳并病而设。方用小柴胡汤疏解少阳之邪以利枢机，桂枝汤调和营卫以解太阳在表之邪。服后或出微汗则愈。

2.大柴胡汤证

若太阳病过经而传变为其他经病证，当未具阳明里实证时，本不应采用攻下的方法治疗。医生不明这个道理，竟两次三番用攻下的方法治疗，如果下后，柴胡证即少阳证仍在的，还应先与小柴胡汤和解，俟其蒸蒸而振，却发热汗出而解；若服小柴胡汤，呕仍不止且更甚，心下胃脘部疼痛紧张而拒按，烦躁郁闷也特别厉害，这说明少阳之邪不仅未尽，而且更兼阳明里实热结，此时当治以大柴胡汤两解少阳、阳明之邪为宜。

大柴胡汤由柴胡、黄芩、半夏、生姜、枳实、大黄、大枣、芍药组成。本方为小柴胡汤减去人参、甘草的补益，加大黄、枳实、芍药酸苦而泻，以下阳明燥结，倍用生姜以治呕不止，且可制约大黄之速下。

曾治患者李某，女，54岁。右胁疼痛，掣及胃脘，痛不可忍，满床乱滚，汗出淋漓，唯注射盐酸哌替啶（杜冷丁）方可勉强止痛。其人体肥，面颊潮红，舌根黄腻，脉沉弦滑有力。问其大便已四五日未解，小便黄赤，口苦泛恶，不能饮食。经西医检查，诊断为胆囊炎，亦不排除

胆结石。据笔者分析，实为肝胃气火交郁，气血阻遏不通，故胁、脘疼痛难耐，大便不通，苔黄腻，脉有力，主里已成实，非攻下不能已。

为疏：柴胡18克，黄芩9克，半夏9克，生姜12克，白芍9克，陈皮12克，枳实9克，生大黄9克，生牡蛎12克，郁金9克。

药煎成分三次服，一服痛止，安然入睡；再服，大便解下甚多，心胸甚爽，疼痛未发，口苦、恶心皆除，切其脉转软，换方用调理肝胃之法获效。

3.柴胡加芒硝汤证

如果上述大柴胡汤证，不用大柴胡汤治疗而用巴豆制剂的丸药泻下，这样，大便虽得以泻下，但胃中燥热不能解，自然少阳之邪就更不能解，因而见“胸胁满而呕”的少阳证和“日晡所发潮热”的阳明证。这种大柴胡汤证却用巴豆制成的“丸药”泻下，在治法上是错误的，不仅不能祛邪，反而会更增阳明燥热。此时虽见下利，亦不属虚，乃是实象。特别是见潮热一症，更可确定为阳明腑实无疑。此证当先用小柴胡汤以解少阳经邪，然后再用柴胡加芒硝汤兼治阳明之里实。

柴胡加芒硝汤，即小柴胡汤加芒硝。方用小柴胡汤以解少阳之邪，加芒硝泄热软坚以润阳明胃燥。本方用量小，又不去人参、甘草甘缓之品，故其泻下作用较大柴胡汤为轻。

以上介绍的柴胡桂枝汤，有汗法之意；大柴胡汤，有下法之意；柴胡加芒硝汤，有调和胃气之意。但上述三方，均是在小柴胡汤和解少阳的基础上加减化裁的，故又非一般发汗、泻下之可比。因此，尽管用汗、用下，但并不失少阳之禁，其立法用方之意，使人玩味无穷。

4.柴胡桂枝干姜汤证

少阳主枢，介于表里、阴阳之间，影响于阳明、太阴之胃与脾。少阳枢机不利而兼胃家实热的，属大柴胡汤证，已如前述；若兼有太阴脾虚寒的，则属柴胡桂枝干姜汤证。

柴胡桂枝干姜汤证，可续发于太阳病。如伤寒五六日，已发汗不愈，而又用攻下，以致邪陷少阳，气郁不舒，故胸胁满微结；胆火上炎

而灼津，故心烦、口渴；热郁不得宣泄而上蒸，故但头汗出；正邪分争，故往来寒热；无关于胃，故不呕；三焦气机阻滞，所以小便不利；内伤脾气，太阴虚寒，故见腹满或大便溏泄。此证是为胆热而脾寒，故治应清少阳之热，兼温太阴之寒，用柴胡桂枝干姜汤。

柴胡桂枝干姜汤由柴胡、黄芩、天花粉、牡蛎、桂枝、干姜、炙甘草组成。本方亦是由小柴胡汤加减化裁而来。《伤寒论》中小柴胡汤有“胸中烦而不呕者，去半夏、人参，加栝蒌实一枚；若渴，去半夏，加人参合前成四两半，栝蒌根四两”的加减法，今见心烦、口渴而不呕，故减去人参、半夏，加栝蒌根以滋阴液而胜热。“若胁下痞鞭，去大枣加牡蛎”，今胁下满微结，即为痞硬之征，故去大枣加牡蛎。“若心下悸、小便不利者，去黄芩加茯苓”，今虽小便不利，但心不悸而见烦，说明是津少而有热，并非蓄水，故留黄芩使其清热；无水邪，故不加茯苓。以干姜易生姜，并加桂枝，取其辛温散结，温中散寒以行气津，故初服药可见微烦，再服则表里和、阳气通、津液行，因而“汗出便愈”。

有患者刘某，男，36岁。因患肝炎住某传染病院，症见：肝区疼痛绕于后背，腹苦胀满，尤以下午为甚，大便溏泄，每日三四次，饮食衰减，体疲乏力。脉沉弦而缓，舌淡苔白。查肝功能：丙氨酸氨基转移酶22单位/升、麝香草酚浊度试验8单位、麝香草酚絮状试验正常。此证肝热而脾寒，中气不运，清阳不升，是以腹胀而便溏，肝气疏泄不利，血脉不和，故肝区作痛绕于后背。脉见弦缓，舌淡苔白，太阴虚寒之象已露，宜治以柴胡桂枝干姜汤：柴胡9克，黄芩3克，干姜6克，桂枝6克，天花粉12克，牡蛎12克，炙甘草10克。服三剂，腹胀明显减轻，大便次数减少，饮食好转。

《伤寒论》在少阳病变治法中，提出大柴胡汤和柴胡桂枝干姜汤，这两个方子可以说是并行不悖的。实践证明，凡少阳而兼阳明实热，则当治以大柴胡汤；若兼太阴虚寒，则非柴胡桂枝干姜汤而不能治。

5.柴胡加龙骨牡蛎汤证

伤寒八九日，邪未传里成实，误用下法，导致邪气内陷，使三阳均受邪扰。少阳胆气被郁而失于决断，故见胸满烦惊；太阳之腑受邪，气化不行，故小便不利；阳明燥热成实，故见谵语。由于三阳皆受邪气，使太阳不开，阳明失合，而少阳枢机亦不利，故其人“一身尽重，不可

转侧”。三阳俱病，主要应治在少阳，兼以泻热镇惊，用柴胡加龙骨牡蛎汤。

柴胡加龙骨牡蛎汤由柴胡、龙骨、黄芩、生姜、铅丹、人参、桂枝、茯苓、半夏、大黄、牡蛎、大枣组成。本方以小柴胡汤为主要部分，而解少阳表里错杂之邪；去甘草之缓滞，可使邪气速去；加桂枝、茯苓行太阳之气而利小便；加大黄以泻阳明热实而治谵语；加龙骨、牡蛎、铅丹镇肝胆以止烦惊。三阳热邪得解，气血流通，其身重等证也随之而愈。

本方在临床上用治精神分裂症有一定疗效，凡是肝胆气郁而致精神失常，并有胸胁满闷、口苦、惊怖不安、大便干或不爽等症者，即可使用。铅丹有毒，用量不宜大，也不可常服，应包煎。

曾治张某，男，12岁。患舞蹈症一年有余，屡治不效。就诊时，患儿手舞足蹈，跳跃不休，令人望而烦乱。脉弦滑，苔白腻。其证属肝胆火郁而动风，痰热扰神而躁动不安，用柴胡加龙骨牡蛎汤，更加胆星、竹茹、天竺黄等清痰热息风之品，进十数剂而躁止神安。

（六）热入血室证治

热入血室是妇女月经期间感受外邪，邪热与血相互搏结而成的一种病变。因其证见胸胁满、寒热往来，病属少阳，故在本篇介绍。

关于血室，有人认为是冲脉，也有人认为是肝脏，但多数人认为就是胞宫，即子宫。胞宫，有主月经和孕育胎儿的作用。由于“冲为血海”、“肝主藏血”，正常的月经与胎儿的孕育均有赖于血液的供应与营养，故胞宫（血室）无疑与冲脉和肝脏有着密切的关系。当妇女正来月经，或月经刚刚来过，或是产后，由于血室空虚，即“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏”，热与血结，影响了肝胆的疏泄功能，因而发生热入血室病证。由于邪热内陷的深浅不同，故热入血室表现的证候也不一样。

如妇人患中风或伤寒，见发热、恶寒等太阳表证，这时又来月经，由于血室空虚，表邪乘虚内陷血室。表邪入里与血结，故热除身凉而脉迟；血室受邪，肝胆疏泄不利，气血不和，故见胸胁下满，状如结胸；血热扰心，则可发生谵语。本证邪结偏于里，故用刺期门的方法，以泻肝经实热。

若妇人中风或伤寒至七八日之久，连续发作定时的寒热，虽得病之初，月事已来，但既病之后经水适断，说明表邪内陷，热入血室。热与血结，滞而不行，故经断；正邪交争，影响了少阳枢机不利，故往来寒热，像疟疾一样，而发作有时，治疗用小柴胡汤，疏解血室之邪热，以利少阳之枢利。因经水适断的“热入血室，其血必结”，故用小柴胡汤治疗时，可酌加生地、丹皮、桃仁、红花、赤芍等清热凉血，活血化瘀药物。

热入血室还有表现为妇人患太阳伤寒，由于经水适来，邪热乘虚而内陷；因为心主血，血属阴，夜为阴，血热扰心，入夜则神识昏糊，“谵语，如见鬼状”；气分无病，故白天神志明了。邪热内陷，入于血室而不在胃，故不能用承气汤攻下；邪已离表，当然也不能再用解表的方法治疗，所以《伤寒论》中提出“无犯胃气及上二焦”的治疗禁忌。同样道理，若妇人患阳明病而见经行下血，热入血室，发生谵语、头汗出等证，当用刺期门，泻肝经实热的方法治疗，不能误认为是胃家实热而施以攻下。

六、合病、并病

（一）太阳阳明合病

太阳与阳明二经同时受邪，相合为病，就叫做太阳阳明合病。二经合病，邪气多较为盛实，常见于以下几种情况。

若既有脉浮、发热、恶寒、无汗、头项强痛的太阳经证，同时也见“缘缘面赤，目痛，鼻干”等阳明经证；且由于太阳与阳明经表受邪，气实于表而不能主里，影响阳明胃肠之气不和而见下利或呕逆；或只表现为太阳经表证，同时因表邪太盛而内迫胃肠，上逆则呕，下奔则利；以上两种情况均属于太阳阳明合病。因胃肠之里不和主要是来自于表邪郁闭，故治疗当解表以和里。见下利的，用葛根汤解表、升清阳以止利；“不下利但呕者”，用葛根加半夏汤解表和里，降逆止呕。

还有一种是太阳表不解，肺气不宣，影响大肠腑气不得通降，见喘而胸满、不大便的，因并非里实，故不可攻下，可以麻黄汤解表宣肺，肺气得以宣降，则喘满、不大便随之可愈。

（二）太阳少阳合病

太阳少阳合病，指两经同时受邪，相合为病，既见太阳表证，又见少阳半表半里证。前面介绍的柴胡桂枝汤证，也可以看做是太阳与少阳合病而偏于表邪盛的一种类型。若太阳与少阳合病，以少阳半表半里之热邪为主，邪热下迫于肠，则见腹痛、下利；上迫于胃，则可见呕逆。其病主要在少阳，故汗下均非所宜，可用黄芩汤清泄少阳邪热以止利；若呕者，可用黄芩加半夏生姜汤清泄少阳，降逆和胃以止呕。

黄芩汤由黄芩、芍药、炙甘草、大枣组成。黄芩清泄少阳邪热，兼清大肠之热；芍药调血和肝而敛阴，合甘草可缓急止痛；大枣合甘草，可健脾和中。半夏、生姜善能散饮降逆以止呕。本方治热痢有很好疗

效，后世许多治痢疾的方子多由此化裁而来，故本方有“治痢祖方”之称。

（三）阳明少阳合病

阳明少阳合病，亦见下利。但因脉见滑数，主内有宿食，也就是病变偏于阳明，故当以大承气汤泻下。以方测证，可知阳明少阳合病之下利，属于热结旁流，并应兼见腹满疼痛拒按、潮热、手足濇然汗出等证。此时虽有少许少阳证存在，亦不必有所疑虑，而当从阳明论治施以攻下法。《伤寒论》中提出的“脉滑而数者，有宿食也”，就是可下的依据。但由于少阳属木，阳明属土，两者之间有其制约的关系，其病变亦互相影响。若病下利，见滑数或沉实的阳明里实脉，为脉证相符，即阳明“不负”为顺，则可用攻下；若见少阳脉弦，是为木来乘土，“互相克贼，名为负也”，主阳明胃气不足，少阳邪气为甚，就不能施以攻下之法。

（四）三阳合病

太阳、阳明、少阳三阳经同时受邪而俱病，称为“三阳合病”。前面少阳病篇介绍的“三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗”，是病变偏于少阳枢机不利，故治以小柴胡汤和解表里。若三阳合病，偏重于阳明热盛的，则见证与治法均与前者不同。由于三阳之热偏结于里，故见腹满；太阳主背，阳明主腹，少阳主胁，三阳俱为热邪所困，则一身尽重，难以转侧；胃气通于口，胃热甚则口不知味；阳明经循于面，热邪郁蒸则面污垢不泽；胃热扰心，故见谵语；热迫膀胱失约，因而遗尿；热蒸津液外泄，所以自汗出。综合上述见证不难看出，虽属三阳合病，而邪热却偏盛于胃，因此治疗当从阳明热证下手，用白虎汤。如果不清阳明之热，而发太阳之汗，则津液愈伤，燥热愈甚，必更增谵语；本证虽热盛阳明，但并未形成腑实，因而也不宜攻下，若误下伤阳，则可引起手足逆冷，额头生汗的亡阳之变。

（五）太阳阳明并病

本太阳病，因汗出不彻而转属阳明，同时太阳表证仍在，则为太阳阳明并病，《伤寒论》中又称“二阳并病”。太阳阳明并病，由于太阳表证未能尽解，即“太阳病证不罢”，故虽有阳明证，亦不可先用下法，应以小汗法轻透表邪。若发汗太过，则有增加阳明胃燥的弊病。若因汗先出不彻而转属阳明，内热外蒸则汗出，表邪入里而不恶寒，此时太阳表证已罢，可用调胃承气汤和其胃气则愈。若太阳之邪未传入阳明之腑，而传于阳明之经，见面色缘缘正赤，说明在经之邪不解，阳气怫郁在表不得发越，当伴有发热、恶寒等表证，治疗应以葛根汤宣散阳明经阳郁之邪，或配合以熏蒸的方法发其汗。假如施以上法而发汗仍不透彻，以致阳郁化热，可使人烦躁不安；邪气闭郁，不得外散而循经流行，营卫因之凝涩，故痛无定处，“乍在腹中，乍在四肢，按之不可得”；外邪闭郁，肺气失宣，故“其人短气但坐”而不得卧；营卫凝滞，血脉运行不利，故脉涩滞而不畅。脉证相合，一派闭郁阻塞之象，溯其病源，皆由于汗出不彻所致。治疗当继续解表，以疏散营卫之邪，即“更发汗则愈”。

（六）太阳少阳并病

太阳病证未罢而并及少阳，是为太阳少阳并病，简称“太少并病”。头项强痛，是太阳病不解；头目眩晕甚则昏冒，是少阳见证；少阳气郁不舒，故胸脘（心下）痞硬，时如结胸。邪在太阳、少阳二经，虽有进一步内陷趋势，但心下痞硬亦并非阳明里实，所以本证既不宜发汗，也不能攻下，可采用针刺大椎、肺俞、肝俞的方法，以宣散太阳并疏泄少阳之邪。如果误用汗法，必助热伤津化燥而生谵语；若里未成实，仍见脉弦等少阳证者，又不能用下法，可刺期门以泻肝经实热邪气。如果误以心下痞硬为实，用攻下，可导致邪热内陷而成结胸；或造成里虚气陷而下脱，出现“下利不止，水浆不下”；正气内虚，邪热上扰，则“其人心烦”。总之，太少并病误下多产生不良后果，应当引起注意，故《伤寒论》中特别强调“慎勿下之”。

（七）少阳阳明并病

少阳半表半里证不解，又涉及阳明之里病者，即为少阳阳明并病。

《伤寒论》中虽未明确提出“少阳阳明并病”，但实际上这种病证是存在的，在前边所介绍的内容中也已有所论及。如“阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者”；“阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白胎者”，均有一定的少阳阳明并病的倾向。因其病虽有阳明证，但尚未成实，故仍宜以小柴胡汤和解表里，使其上焦得通，津液得下，胃气因和则愈，而不能过早地攻下。再如大柴胡汤证、柴胡加芒硝汤证，若来自少阳证不解，又并见阳明里实证者，亦可以说属于少阳阳明并病。

七、辨太阴病脉证并治

太阴病，是三阴病的开始阶段。病入三阴，以虚寒病变为主，太阴病主要表现为足太阴脾的虚寒证。脾赖阳气运化，脾阳充盛，则水谷精微能够得到运化输布，以营养脏腑器官、四肢百骸；若脾阳虚衰，则中阳不运，寒湿不化，即可形成太阴病。

太阴病，有传经而来的，有寒邪直中而成的，亦有因误治伤害脾阳而发病的，其主要临床表现以腹满时痛、食不下、呕吐、下利等症状为主。

三阴为三阳之里，而三阴亦自有表里，故风寒邪气所中，不一定全入于脏，表现为太阴脏病，亦有邪气在经表现为太阴经病的。若既有经证，又见脏证，则为经脏表里俱病。同时，太阴与阳明为表里，“虚则太阴，实则阳明”，故太阴病中，有兼及阳明燥化而出现腹满疼痛拒按的实证，因属太阴转系之邪，所以与阳明承气汤证又不尽相同。

太阴病的治疗，以温中扶阳，运化寒湿为正治之法，至于或汗或下，则为随证施治之法。本篇先论脏病，次论经病，又次为经脏俱病，以示太阴病的重点所在。

（一）太阴病辨证纲要

脾主腹。太阴为病，无论传经而成，或因寒湿直中，或误治损伤脾阳，凡致脾阳不运，寒湿内阻，无不表现为腹胀满；寒凝中州，所以在腹满的同时，还常兼见腹痛，因属虚寒，故疼痛喜温喜按。脾与胃相为表里，寒湿困脾，清阳不升，水谷不化，故见下利；寒湿犯胃，浊阴不降，胃气上逆，故而作吐。脾运不健，胃气呆滞，所以饮食不下。下利本属虚寒，越下利则虚寒越甚，因而上述诸证也就越加重。病属虚寒，治当温补，若误以实治而用苦寒攻下，则寒湿更加凝结，痞塞于胸膈，则见胸下结硬。《伤寒论》在太阴篇首提出“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛”，正是抓住了太阴病证的主要特点，并

以此作为太阴病的辨证纲要。

（二）太阴脏病证治

太阴脏病，即脾虚寒证，其主要临床表现已如上述。三阴病均可见下利，但由于太阴病是脾虚寒，中阳不运，寒湿不化，故其病虽见下利而口却不渴，故《伤寒论》中说“自利不渴者，属太阴，以其藏有寒故也”。寒者温之，虚者补之。太阴虚寒，治当温补，“宜服四逆辈”，即四逆汤一类的温阳祛寒剂，具体地说，可服理中汤以温中散寒，健脾运湿。

理中汤（一名人参汤），由人参、白术、干姜、炙甘草组成。方用人参、炙甘草补脾气之虚，干姜、白术扶中阳以化寒湿之邪。本方既可做丸服，也可用汤剂。服后片刻服热稀粥一碗，腹中由冷转温则病愈；如不温，可继续服药。若下利寒甚，属脾肾双虚的，可再加附子，兼温少阴肾阳。

太阴病有因误治而形成的。如本属太阳病，不发汗反用下法，致使里虚邪陷，转变成为太阴病。此证虽不见吐利，但出现腹满时痛的脾病证候，故亦“属太阴也”。治疗用桂枝加芍药汤，以调和脾家气血，缓解腹痛。桂枝加芍药汤，即桂枝汤倍用芍药。方用桂枝汤调气血营卫以和中州阴阳，加重芍药用量以和血脉、缓急而止痛。

若腹满疼痛更甚，以致拒按，大便也不通利，即“大实痛者”，说明里虚邪陷不仅转属太阴，而且又累及阳明，既见有可下之实证，则当于上方中再加大黄以泻其实。桂枝加芍药汤再加大黄，即成为桂枝加大黄汤。本方用桂枝加芍药汤调和太阴脾家气血，用大黄泻下阳明胃腑实滞。然太阴病终不免脾虚不足，因此大黄、芍药等苦酸性寒药物应该慎用。如果患者脉弱无力，又见下利之证，虽有大实痛，此方亦不可用。倘若不得已用之，亦宜减少其用量。这是因为脉弱而便利，反映了病人胃气弱而不振，邪气不聚而易动，故治疗时只可缓图而不能峻攻。

脾与胃为表里，太阳病不解而邪内陷，既可转属阳明，亦可内连太阴。若其人小便数多，大便因硬，手足濇然汗出，是转属阳明的标志；若脉浮缓，不得汗出，小便不利，手足自温，身发黄，则为“系在太阴”。太阴为湿土，太阴受邪，热与湿合，湿热郁蒸，可发为黄疸。若小便自利，湿有出路，就不能郁蒸为黄。湿热相搏，至七八日，若见大便秘者，是湿邪化燥，即转属阳明；若不见大便秘，而出现暴烦下利，

则是正气振作，邪气欲去之象，虽下利日十余次，终必自止。这是因为肠中有腐秽之物，当脾气恢复，能以逐邪外出的时候则见下利，下利是排除邪气的一种表现形式，与战汗有相似的意义；一旦邪气去而腐秽尽，下利亦必自然停止。由此可见，太阴病下利，其中有属于正气逐邪外出的，亦不可不知。

太阴病发黄的治法，可参照阳明病篇，属于寒湿发黄，即“阴黄”者，当治以温化；属于湿热发黄，即“阳黄”者，则当治以清利。

（三）太阴经病证治

脾气行于四肢，风又善浸淫四末为病，故太阴中风，证见四肢疼痛得很厉害。四肢为太阴之表，内与太阴脾相合，即“脾主四肢”。若此时其人脉浮，浮主表，是太阴经表受邪，故仍可以桂枝汤发汗；若脉见“阳微阴涩而长者，为欲愈”。“阳微阴涩”，指脉浮取而微，沉取而涩，是邪不盛而正亦不充之象。微、涩之脉，俱为阴脉。若在微涩脉中见有长脉者，则是正气来复，邪气衰退的表现，阴病见阳脉，故曰欲愈。

（四）太阴经脏俱病证治

太阴经脏俱病，是为表里皆寒之证。脏有寒则下利、腹胀满，经有寒故肢体疼痛。经脏表里俱病，治疗当先温里，用四逆汤，里证愈而经表之邪仍不解，再用桂枝汤攻表。太阴经脏俱病，为什么要先温里而后再攻表呢？这是因为太阴脏气不充，外攻无力；若先发汗攻表，必致阳气外泄，里寒反增，只有先温其里而后救其表，才能达到扶正以祛邪，邪却而正安的目的。

八、辨少阴病脉证并治

少阴包括手少阴心和足少阴肾，因此，少阴病也就是心肾疾患。

心主火，肾主水，心肾统摄人体水火阴阳之气。肾为阴阳之根，真气之所系。心火居上，肾水在下，心肾借经脉之通道，使水火上下交济，以维持人体的阴阳平衡。病至少阴，心肾功能受损，阴阳失去平衡，火衰者表现为阳虚寒证；水亏者表现为阴虚热证；若阴阳离决，精气脱竭，则可出现死证。

肾为主水之脏，少阴病阴阳失调而不能主水以行津液，又常见小便不利，水气泛滥的证候。

少阴与太阳为表里，故有邪在太阳而内及少阴的，亦有寒中少阴而仍外连太阳的表里同病。又因少阴居太阴与厥阴之间，少阴病可外合太阴见吐利，亦可内合厥阴见厥逆，故少阴有“主三阴之枢”的说法。

少阴病有来自传经的，有属外邪直中的，也有因误治损伤了心肾水火阴阳而形成的。

少阴病以阳虚的寒化证为主，以“脉微细，但欲寐”为主要临床表现。若寒化证见恶寒、身蜷、手足厥逆等证，则为病进；若更见下利、脉不至的，则属病危。

少阴病治法，若属阳虚阴盛的寒化证，则应扶阳以抑阴，有水者当兼以化水；若属阴虚阳亢的热化证，则以育阴为主，有火者当兼以清火。由于少阴病以阳虚为主，故治疗当以回阳为急务。

（一）少阴病辨证纲要

少阴之为病，其阴阳皆虚，验之于脉，阳虚则脉微，阴虚则脉细，阴阳俱虚，故脉微细。少阴以阳虚为主，故阳光不振，神疲多寐而又不能熟睡，表现为精神萎靡昏沉，瞌睡不醒的“但欲寐”状态。

曾治过一位姓唐的老人，年逾古稀，冬月患外感，头痛发热，鼻流

清涕。自服羚翘解毒丸，前后共进6丸，即觉精神甚疲，手足发凉。其子请笔者为之诊治。持脉未久，发现患者即侧头欲睡，脉不浮反沉，舌淡嫩苔白。笔者当即告诉病家：此证属少阴伤寒，肾阳已虚，如再进凉药恐生叵测，而治当急温，以回肾阳，予四逆汤。服一剂则神转旺，再剂手足转温。从此例可以看出，“但欲寐”对少阴病确有极为重要的辨证意义。

“脉微细，但欲寐”，作为少阴病的辨证纲要，可以说是对少阴病脉证的总概括。但如果少阴病初受邪扰，正邪交争而少阴气馁，欲受不甘，欲拒而又不能，其证见“欲吐不吐，心烦”；阳气为寒邪所困，阴气用事，则又“但欲寐”。此时，少阴主证已见，法当急温。若不能及时治疗，拖延至五六日，则必致邪入更深，正气益衰。肾主水，心主火。少阴心肾功能衰减，下水无阳以温则下利；上火无阴以济则口渴，水津得不到阳气的蒸化上承，势必干渴欲饮水自救。心烦，口渴引饮，颇似阳热之证；若真是阳热证候，则当大便干结，小便黄赤；而今却见下利，小便色白，说明并非实热，而是属于少阴虚寒，即如《伤寒论》中所说“下焦虚有寒，不能制水”的病变。

综上所述，可知凡少阴心肾阴阳俱虚，则必见脉微细，但欲寐；若下焦肾阳虚衰，心肾水火不相既济，则以烦渴，下利而小便色白为辨证要点。

（二）少阴病寒证

少阴寒证，是少阴病的主要病变，证情变化多而复杂，且具有不少危重证候，故作为本篇的重点讲述。

1.麻黄附子细辛汤证与麻黄附子甘草汤证

少阴与太阳为表里，有经脉相连而其气相通。若寒邪侵犯少阴，本不应见发热，而反见发热，说明是寒邪初犯，仍外连太阳；既外连太阳之表，则应见浮脉，而今却见脉沉，又反映了内系少阴，阳气不足，抗邪无力。少阴病“反发热，脉沉者”，是属太阳、少阴表里俱病，也就是“两感”证，治当温经散寒，表里兼顾，治用麻黄附子细辛汤。

麻黄附子细辛汤由麻黄、附子、细辛组成。方用麻黄发太阳之汗，以解在表的寒邪；附子温少阴之里，以扶阳气之虚；细辛专走少阴，能资助麻黄、附子以散表里之寒。三药配合，补散兼施，扶正以祛邪，虽发微汗，但无损于阳气，故为温经散寒之良方。

太阳、少阴的“两感”证，常见于年老体弱之人，因其阳气不足，卫外无力，故感受寒邪，则表里俱病。寒邪初犯，可用麻黄附子细辛汤；若已“得之二三日”，虽寒邪并未尽入少阴之里，但亦应考虑正已转虚，因而就不宜再用麻黄附子细辛汤，当以麻黄附子甘草汤治疗。

麻黄附子甘草汤，即由麻黄附子细辛汤去细辛，加甘草组成。去细辛，则减少了发散的力量使之不伤正气；加甘草，则有助于扶正补虚的作用。尤在泾说：“寒邪不可不发，而阴病又不可过发。”这可以说是由麻黄附子细辛汤而变为麻黄附子甘草汤的用意。

上述少阴与太阳的表里皆病，应与“太阳病篇”的“病发热头痛，脉反沉”证候互参。彼以太阳为主，故曰“脉反沉”；而此以少阴为主，故谓“反发热”，这两条前后呼应，互相参证。

太阳与少阴为表里，关系之紧密，犹如唇齿之相依。少阴病连太阳，则为表里同病；若太阳伤寒，脉阴阳俱紧，本当无汗而反见汗出的，说明是寒邪过盛而伤害了少阴阳气，“此属少阴”。因为少阴肾阳为一身阳气之根，少阴阳虚则卫阳亦随之而虚，卫阳失去固护荣阴的作用，所以汗出。少阴之脉，上膈循喉咙；肾为胃之关而下司二阴，若太阳寒邪长驱直入而飞渡少阴，致使少阴经藏俱病，则可出现咽痛和吐利等证。

2.附子汤证

少阴病，得之一二日，不发热而见背部恶寒，背为阳之府，背部恶寒是阳气衰、阴气盛的征象。寒邪入里，病发于阴，阳虚而阴盛，故口不渴、不燥而“口中和”。四肢为诸阳之本，阳虚不达四末，所以手足发凉。阳虚阴盛，寒湿凝滞，故见身疼、骨节疼痛。太阳伤寒，见发热、恶寒、无汗、身疼、骨节疼痛，脉必浮，属麻黄汤证；本证见无热、手足寒、身疼、骨节疼痛，脉不浮而沉，则属少阴阳虚里寒。治疗可先用灸法，如灸关元穴以助元阳而消阴，然后以附子汤温阳益气，固本培元。

附子汤由炮附子、茯苓、人参、白术、芍药组成。方用附子温肾以

扶真阳之本，用人参大补元气，茯苓、白术配附子可温化寒湿之凝滞；又可佐人参健脾益气。芍药敛阴和血，既可缓身痛，又可制诸药的温燥，并能引阳药入阴分。此方脾肾双补，先天后天兼顾，为扶阳固本的代表方，后世的参附汤即从此方演出。

3.真武汤证

本证在太阳病篇是作为太阳病发汗太过，伤了阳气而形成的变证提出的。伤阳实际上是伤了肾阳，其病则为少阴病。

若寒邪中于少阴，二三日不愈，至四五日邪气入深，则脏受其病。少阴肾中阳气被寒邪所伤，以致阳虚不能制水，水邪随之泛滥而为病。水寒凝于内，则腹痛；气不化液，故小便不利；水寒外溢，阴凝重着，故四肢沉重疼痛；下注于肠，故自下利。水邪为病变动不居，可到处泛滥而为患，因而或见之证甚多，若上凌心肺，可见心悸而咳；上逆于胃，则气逆而呕；泛滥肌肤则肿；上蒙清阳，则头目眩晕。究其病源，却均因于水，《伤寒论》中说“此为有水气”，指出了病变的重点与要害所在。治以真武汤，温阳驱寒以利水（方见太阳病篇）。

附子汤与真武汤均为温阳之剂，其药物组成仅有一味药之差，但两方的作用是不相同的，柯韵伯指出，附子汤为“大温大补之方……与真武汤似同而实异，倍术附去姜加参，是温补以壮元阳，真武汤还是温散而利肾水也”。

4.四逆汤证

少阴阳气为一身阳气之总司。阳气有腐熟水谷，蒸化输布水液的作用。少阴阳虚，不能腐熟水谷，不能气化水液，因而或见下利清谷，或致寒饮停聚膈上，使人干呕欲吐而又无物吐出；阳虚不达四末，故手足发凉，甚则四肢厥逆。膈上有寒饮亦当分辨虚实，若因少阴阳虚而不能敷布，则脉必沉而微细；若脉弦迟有力或关尺皆沉，寸脉微浮，则属胸中寒实之证。因弦脉主饮，迟脉主寒，寸脉以候胸中。胸中寒痰实邪，闭阻胸阳不达于四末，故见手足厥寒；由于胸膈痰饮实邪的格拒，所以“饮食入口则吐”，但又不能吐；痰饮实邪填塞胸中，阻滞气机，故见“胸中痞鞭，气上冲咽喉不得息”等证候，反映了邪有上越之机。以上

虚实病证不同，治法亦不同。如病属少阴阳虚，虚寒从下而上，致使寒饮停于胸膈的，治以四逆汤温少阴化寒饮；若属于寒痰阻滞胸中的实证，根据“病在上者，因而越之”的法则，治以吐法，用瓜蒂散。

四逆汤由附子（生）、干姜、炙甘草组成。附子温少阴以回阳，干姜温中以散寒，炙甘草和中补虚，三药配伍，共奏回阳救逆之功。

肾为先天之本，若少阴阳气一衰，则周身阳气也皆衰，所以当少阴真阳衰竭，证候显露，应速投四逆汤急温，绝不可因循观望。故《伤寒论》中说“少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤”。

瓜蒂散，即取瓜蒂、赤小豆捣为散，再用香豉煮做稀糜，取汁合散。方中瓜蒂味极苦，性升而善催吐；赤小豆味苦酸，功能利水消肿；两药配合，有酸苦涌泄之功。用香豉汁送药，清轻宣泄，可加强涌吐的作用。本方专治胸中实证，涌吐力猛，故“诸亡血虚家”不可用。

瓜蒂散证，因可见发热、汗出，“病如桂枝证”，但头不痛、项不强，故在太阳病篇提出以作鉴别比较；本证又在少阴病篇提出，是为陪衬少阴阳虚有饮，以示阳虚寒饮与阳郁痰实两种病证的鉴别诊断。

5.通脉四逆汤证

少阴为水火之脏，阴阳之根，若寒中少阴，阴寒太盛而反格阳于外，可形成阴盛格阳证。阴盛于内，则下利清谷，手足厥逆，脉微欲绝；阳格于外，则见身热不恶寒，面色红赤。由于上述证候是阳虚甚极，阴寒过盛导致的阴阳格拒之证，故其证是“里寒外热”，实为真寒假热。从病变机制及临床表现看，本证较四逆汤证为重，若不抓紧救治，恐有脱汗亡阳之变。治疗当以通脉四逆汤逐寒摄阳，通脉救逆。

通脉四逆汤的药物组成与四逆汤同，只是加大了干姜和附子的用量，因而回阳救逆的作用比四逆汤更强。若在通脉四逆汤证的基础上更见面色赤的，是为阴盛于下格阳于上的“戴阳”证，应于本方中加葱白以破阴驱寒，招纳阳气；若因肝脾血脉不和而见腹中痛的，则减去辛滑走阳而不利血之葱白，加芍药以利血脉缓急止痛；若胃气挟饮邪上逆而作呕的，则加生姜化饮止呕；若邪气循少阴经脉上犯而为喉痹咽痛的，则去芍药之酸敛，加桔梗以开喉痹；若利止脉不出，是阴阳衰竭，气血大虚，当加人参以复脉，去桔梗以防耗气伤正。

“徐国桢伤寒六七日，身热目赤，索水到前，复置而不饮，异常大

躁，将门牖洞启，身卧地上，辗转不快，更求入井。一医汹汹急以承气与服。余诊其脉洪大无伦，重按无力。余曰：阳欲暴脱，外显假热，内有真寒，以姜附投之，尚恐不能回阳之任，况敢以纯阴之药，重劫其阳乎？观其得水不欲咽，情已大露，岂水尚不能咽，而反可咽大黄、芒硝乎？天气懊蒸，必有大雨，此证顷刻一身大汗，不可救矣。于是以附子、干姜各五钱，人参三钱，甘草二钱，煎成冷服。服后寒战戛齿有声，以重棉和头覆之，缩手不肯与诊，阳微之状始著，再与前药一剂，微汗热退而安。”（引自《寓意草》）

6.白通汤与白通加猪胆汁汤证

若少阴病下利，脉微而沉伏，是为寒邪直中，阴盛抑阳，以致阳气暴虚，既不能固其内，又不能通于脉，因而比一般寒证为甚，当治以白通汤扶阳破阴。

白通汤由葱白、生附子、干姜组成。方用干姜、附子温经回阳以散寒；葱白辛滑性热，善能通阳气破阴寒，用于温阳剂中，可疏通被郁之阳气，故取名“白通汤”。

若服白通汤后，不但未奏效，反见下利不止，厥逆无脉，干呕而烦等证，一方面说明阴寒太盛，对大热之药拒而不受，并更加激发寒邪而变本加厉；另一方面也说明下利之后，不仅阳气受伤，而且阴液亦耗损，白通汤只能扶阳不能育阴，阴不复则脉不出，阴不敛阳，虚热浮于上，故干呕而烦。基于上述两个原因，本证的治疗就不是单纯的温热回阳剂所能胜任，而应于白通汤中加入人尿和猪胆汁，扶阳育阴，且以苦寒反佐，使同气相求，引阳药直入阴中。

白通加猪胆汁汤，即白通汤加人尿、猪胆汁。人尿（一般用童便）咸寒益阴，猪胆汁苦寒滋液兼清虚热，两药取之人、畜，皆属有情之品，既能续已竭之阴，滋将涸之液，又能借其性寒反佐，引阳药直入阴分，使阴阳不发生格拒，这就是“甚者从之”治法的具体运用。

服白通加猪胆汁汤以后，若脉从无到有，从弱到强，说明正气逐渐恢复，阴邪逐渐消退，为向愈之证，即脉“微续者生”；若脉暴而出，或见浮散而大，或见急促无根，则是无根之阳暴脱的征象，预后多不良，因而《伤寒论》中说“脉暴出者死”。

7.吴茱萸汤证

本证属于胃气虚寒证，已在阳明病篇作过介绍。这里所讲的是少阴病感寒，寒浊上犯于胃则呕吐，下迫于肠则下利；阳气被寒邪所遏伤，不能温养四末，故手足逆冷；由于阳气仅被寒邪所抑，并未衰亡，尚有力能与阴寒交争，故其人烦躁特甚以致难以忍受。本证虽言“少阴病吐利”，但因其以呕吐为主，病变重心仍属中焦虚寒，故还以吴茱萸汤温胃散寒以降逆止呕。

曾治伍某，女，32岁。患者胃脘疼痛，呕吐水涎，入夜烦躁难忍，坐卧不安，头疼而眩冒，脉弦缓无力，舌淡苔白而水滑。初诊辨为胃气虚寒，投香砂六君汤，但效果不显。再诊始悟烦躁、吐涎是为吴茱萸汤之见证。遂开是方两剂，服之而愈。

8.桃花汤证

下利、便脓血，常见于热证，亦可见于少阴虚寒证。如少阴病，二日至四五日，虚寒下利而不能止，邪气入深，久病入络，由气及血，以致脾肾阳虚，气不摄血，大便滑脱不固而便脓血。因其证属虚寒，故腹痛隐隐，喜温喜按；脾肾阳虚，水谷不别，故大便泄利不止，小便却反少而不利。热利便脓血，表现为血色鲜明、气味臭秽，并伴有里急后重、肛门灼热感；少阴虚寒下利便脓血，则以血色晦暗或浅淡，无臭秽气味，大便滑脱不禁，无肛门灼热感为辨证特点。少阴病下利便脓血，治以桃花汤，温中固脱以止利。

桃花汤由赤石脂、干姜、粳米组成。因其证下利脓血俱出，滑脱不固，故以赤石脂填补下焦、固涩气血以止利；干姜温中散寒，粳米益脾胃而补虚。赤石脂一半煎汤，另一半则用末冲服，其用意是加强药物的吸着固肠作用。服药后，大便止则小便利，脓血除则腹痛止，可见温涩固脱实为治病求本之法。本方对久痢、久泄，凡属虚寒滑脱者，皆可应用。

程某，男，56岁。患肠伤寒住院治疗40余日，基本已愈，唯大便泻下脓血，血多而脓少，日行三四次，腹中时痛，屡治不效。其人面色素来不泽，手脚发凉，体疲食减，六脉弦缓，舌淡而胖大。此证为脾肾阳虚，寒伤血络，下焦失约，属少阴下利便脓血无疑。且因久利之后，不

但大肠滑脱，而气血虚衰亦在所难免，治当温涩固脱保元：

赤石脂30克（一半煎汤，一半研末冲服），炮姜9克，粳米9克，人参9克，黄芪9克。

服三剂而血止，又服三剂大便不泻而体力转佳。转方用归脾汤加减，巩固疗效而收功。

（三）少阴病热证

少阴热证是与少阴寒证相对应的一类证候。少阴为水火之脏，阴阳之根，因而少阴病不仅有阳虚火衰的寒证，而且还有阴虚火旺的热证。下面介绍少阴病热证的几个主要证候的辨别与治法。

1. 黄连阿胶汤证

少阴病，得之二三日以上，若属阳虚阴盛的，则以但欲寐，寤少寐多为主；若属阴虚阳亢的，必见心烦、不得卧寐。因为在正常的生理情况下，心火要不断下降以温肾水，肾水亦不断上承以济心火，少阴心肾水火能以交通既济，才能达到阴平阳秘、阴阳相对平衡状态，从而维持人体正常的精神活动。而今少阴病肾水亏虚，心火无制而上炎，阳不入阴而躁扰于外，就要发生心烦特甚以致不能卧寐的证候。其证属阴虚火旺，故舌质红绛，苔净而光，甚则状若杨梅，脉细数，小便必黄。治以黄连阿胶汤，泻火滋水，交通心肾。

黄连阿胶汤由黄连、黄芩、芍药、阿胶、鸡子黄组成。方用黄连、黄芩泻心火以下降，阿胶滋肾水以上潮，鸡子黄养心血而宁神，芍药和血而敛阴。用本方当注意：阿胶应烊化兑入汤剂中，待汤稍冷再加入鸡子黄，此二药均不得入汤药中同煎。

患者张某，男，25岁。心烦少寐，尤以入夜为甚。自觉居室狭小，憋闷不堪，心烦意乱，常欲奔赴室外。脉数舌红，舌尖部红如草莓。此乃心火燔烧而肾水不能承其上，以致阴阳不交，心肾不能相通，形成火上水下不相既济之证，为疏：黄连阿胶汤加竹叶、龙骨、牡蛎。服一剂则心烦减轻，再一剂即可入睡。

2. 猪苓汤证

少阴肾为水脏，肾对水液的代谢与排泄起着重要作用。肾中有肾阴、肾阳，阳虚可使水不化，阴虚亦可使水停。阴虚阳亢，火热扰心，

故心烦不得眠；水蓄不行，故小便不利；阴虚水停，津液不能上承，故见口渴；水热互结，泛滥三焦，迫于肺则咳，逆于胃则呕，渗于大肠则下利。阴虚停水，水热互结，当治以滋阴清热利水，用猪苓汤。

猪苓汤由猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石组成。方用猪苓、茯苓、泽泻利小便以行水气，滑石清热通淋以利水道，阿胶滋阴润燥以益少阴。本方在临床上用治慢性肾炎，特别是对肾盂肾炎和肾结核，见有小便不利、心烦少寐等证候者有很好的疗效。

本证与黄连阿胶汤证均属少阴阴虚有热证候，但此证为阴虚停水，彼为阴虚火旺。虽然二证都见心烦不寐，但本证以脉细数而弦，舌质红而苔反水滑以及小便不利等辨证特点，有别于黄连阿胶汤证。

黎女，19岁。患慢性肾炎，下肢浮肿，小便红赤灼热而短，心烦少寐，腰酸无力。尿检：红细胞（+++）、蛋白（+）。辨为阴虚有热而水热凝结。为疏：猪苓汤加旱莲草、女贞子、三七粉，共服十二剂，诸证渐愈，查尿：红细胞及蛋白均不见。

3.少阴邪热外转太阳证

少阴与太阳为表里，有经脉相通，其病变可相互影响。前面介绍的麻黄附子细辛汤证就是一个很好的例证。应当指出，少阴与太阳病变的相互影响，不仅表现为寒证的由表及里，而且也可见于热证的由里出表。如少阴病八九日，证见一身及手足都发热，说明少阴邪热还于太阳膀胱之表。一般地说，邪气由里出表，标志着机体的正气较盛，有力驱邪外出，特别是本为少阴虚寒证，而见一身手足转温热，是阳气恢复，疾病向愈的好现象。但如果阳复太过，热在膀胱不解，也会灼伤阴络迫血下行，发生尿血的病变。本证在《伤寒论》中未提出具体治法，后世注家有提出用猪苓汤、黄连阿胶汤的，也有提出用犀角地黄汤的，均可作为参考。

4.四逆散证

少阴主水火，内寓真阴、真阳。水火交通，阴阳既济，是人体正常生命活动的必要条件之一。要维持水火、阴阳的交通既济，有赖于少阴的枢机作用，也就是说少阴不仅为“三阴之枢”，而且也是调节水火、阴

阳的重要枢纽。少阴阳虚不能达于四末，则阴寒必盛，而见四肢逆冷、恶寒、下利等证；若少阴枢机不利，阳气被郁，不能疏达于四末，则亦可见四肢逆冷。少阴阳气被郁，并非阳虚，故不见恶寒、下利等虚寒证，治疗也就不能用四逆汤，应以四逆散疏畅阳郁，条达气血。

四逆散由柴胡、枳实、芍药、炙甘草组成。方用柴胡、枳实解郁开结以疏达阳气，芍药配甘草和血脉以利阴，即“治其阳者，必调其阴，理其气者，必调其血”之义。若兼有肺寒气逆作咳者，可加干姜、五味子以散肺寒、敛肺气；兼心阳不振而作悸者，则加桂枝以温通心阳；水停于下而小便不利者，加茯苓淡渗以利水；寒盛于里而腹中作痛者，加附子温阳散寒以止痛；寒滞气阻而泄利下重者，加薤白以散寒通阳。

曾治患者全某，男，32岁。患者手足厥冷而痛麻不堪，手足汗出随厥之深浅而有多少不同，厥深则手足汗出亦多，厥微则手足汗出亦少。曾服附子、干姜等回阳救逆之药无效。视其人身材高大，面颊丰腴，不像寒厥体征，然握其手却冷如冰铁。其脉弦而任按，舌红而苔白。细思此证既非阳虚之寒厥，又非阳盛之热厥，从其脉弦以辨证，可知属阳郁无疑。阳郁于里，不达四肢故为厥，迫阴外渗则汗出，阳郁愈甚则手足厥逆愈深而汗出亦就愈多，反之，手足汗出亦必然相应减少。为疏四逆散原方，服之以观其效。服药后，患者自觉气往下行至脐下，随之则微微跳动，周身顿感轻爽，而手足转温，汗亦不出。患者甚喜，奔走而告，以为病将从此而愈。不料，两剂服完，手足又厥，汗出依旧。余仍以上方，另加桂枝、牡蛎，意使桂枝配芍药以和营卫，牡蛎得芍药敛汗以固阴。服两剂，厥见温而汗出少，但续服则仍无效，病又反复。手翻医书，见王太仆名言“益火之源以消阴翳，壮水之主以制阳光”，而恍然有悟：此证每方皆效，而不能巩固到底，关键在于只知疏达阳郁，不知滋阴以敌阳。阴不足无以制阳则反逼阴以为汗；阳无偶则自郁而为厥。厥阳之气宜疏，而弱阴岂可不救。于是，本肝肾同治，理气与滋阴并行之法，为疏四逆散与六味地黄汤合方。服六剂，厥回手温而汗止。后追访得知，其病终未复发。

四逆散不单治阳郁之厥，亦治因阳郁不伸，少阴枢机不利的男子阳痿及妇女性功能减退等病证，若见脉弦而情志抑郁者，服之每效。

（四）少阴咽痛证治

少阴经脉循喉咙挟舌本，邪客少阴经或少阴经脉失养，均可引起咽

喉疼痛。

若少阴病二三日，因于邪热上攻而咽喉肿痛，但尚未溃破生疮的，则治以甘草汤，解毒消肿止痛。甘草汤，仅生甘草一味药。生甘草甘寒，甘以缓急止痛，寒以除热解毒。

若服甘草汤，病仍不差即咽喉肿痛不解的，可与桔梗汤散热结、开喉痹。桔梗汤，即甘草汤再加桔梗。方用生甘草清热解毒以止痛，桔梗开痹散结以利咽喉。

若少阴热邪，循经上冲，灼伤咽喉而生疮，以致妨碍语言，声音不出，且伴有大量分泌物缠绕咽喉而不得清除，治以苦酒汤清热解毒，收敛伤口。苦酒汤由半夏、鸡子白、苦酒（醋）组成。半夏涤痰开痹以清除分泌物；鸡子白甘寒，可清热润燥、止痛；苦酒苦酸，善于散邪毒，消疮肿，敛伤口。

若少阴病，寒遏于外，阳郁于内，经气不利，以致咽中痛，痰涎缠喉，咳吐不利，则应用半夏散及汤，散寒涤涎以开结止痛。半夏散由半夏、桂枝、炙甘草组成。方用桂枝通阳散寒，半夏涤痰除涎，甘草和中解毒。本方可用散剂，亦可用汤剂。

若少阴病下利之后出现咽痛，则当考虑阴液耗损，经脉失于濡养所致。少阴虚寒下利，虽然寒可随利而减，但津液亦可随利而夺，阴伤于下则必致阳浮于上。少阴之脉，从肾上贯肝膈，入肺中循喉咙；其支脉，从肺出络心，注胸中。少阴虚热循经上扰，不仅咽痛，而且还可见胸满、心烦等证。本证治疗用凉用温，均为不妥，可以猪肤汤润肺肾、益肠胃而敛虚热。猪肤汤由猪肤、白蜜、白米粉组成。猪肤即猪皮，可滋肺肾，清少阴浮游之火，此物虽润但无滑肠之弊；白蜜甘寒生津，润燥以除烦；白米粉炒焦能醒脾和胃，且补下利之虚。

李某，女，22岁。擅歌唱，经常演出。忽声音嘶哑，咽喉干痛，屡服麦冬、胖大海等药不效。舌红、脉细，辨为肺肾阴亏，虚火上扰，“金破不鸣”之证。授以猪肤汤法，令其调鸡子白，徐徐呷服。尽一剂而嗓音亮，喉痛除。

综上所述可以看出，咽痛是少阴病变的一个特点，其治疗所用的甘草汤与桔梗汤的解毒散结缓痛、苦酒汤的酸收、猪肤汤的清滋以及半夏散的散寒涤涎等法，直至今日仍奉为喉科治疗之圭臬。

（五）少阴病急下证

前面的阳明病篇曾提到大承气汤有三急下证，其主要精神是：凡阳明腑证遇到病势急，发展快，见有劫灼少阴真阴的征象时，当投以大承气汤急下以存阴。从阳明病急下证可以看出阳明燥热与少阴阴伤两种病变的密切联系。若因阳明燥热伤阴而并于少阴者，属阳明急下证；若因少阴水亏，燥热内盛而并于阳明者，则属少阴病急下证。下面就分别介绍少阴病的三急下证：

少阴热邪，并入阳明，时间不长只二三日，即见口燥咽干，说明阳热气盛而阴液衰少。热并阳明，则土实而水亏，其人必兼见胃实等证。不下胃实，则少阴之阴液不能恢复，故应以大承气汤急下。

少阴热并阳明，与糟粕相结，以致胃肠燥结不下，逼迫津液下注旁流，证见“自利清水，色纯青”而不杂粪便；燥热结实于阳明，故“心下必痛”而拒按；少阴阴液耗伤，不能上承，所以口舌干燥。燥结不去，则旁流不止，津液进一步涸竭，将有亡阴脱液的危险，故当用大承气汤急下。

少阴病，六七日不愈，邪气入深，若不见下利清谷，反见“腹胀不大便”，说明其证并非少阴虚寒，而是少阴邪热复还阳明，属于“中阴溜腑”之证。此时见舌苔黄燥，脉沉实有力，亦当用大承气汤，泻热存阴。

《名医类案》记载一病例：孙兆治东华门窦太郎患伤寒，经十余日，口燥舌干而渴，心中疼，自利清水。众医皆相守，但调理耳，汗下皆所不敢。窦氏亲故相谓曰：伤寒邪气，害人性命甚速，安可以不次之疾，投不明之医乎？召孙至曰：明日即已不可下，今日正当下，遂投小承气汤，遂大便通得睡，明日平复。众人皆曰：此证因何下之而愈？孙曰：读书不精，徒有书耳。口燥舌干而渴，岂非少阴证耶？！少阴证，固不可下，岂不闻少阴一证，自利清水，心下痛，下之而愈。仲景之书，明有是说也。众皆钦服。

（六）少阴病治疗禁忌

少阴为阴阳之根，生命之本，故病至少阴，多表现为危重证候。但若治疗及时，或温寒以扶阳，或泻热以存阴，虽病情危重亦多能救治。因此，治疗少阴病不仅要及时，而且一定不能违反治疗禁忌而犯治疗错误。少阴病的治疗禁忌有哪些呢？下面举例加以说明。

“少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗”。脉沉主病在里，细数为阴虚有热，少阴脏病而阴虚有热，治当滋阴降火，而不应发汗，如果强发其汗，则有竭阴耗液之变；若少阴病，阳虚阴盛，阴与阳搏，脉沉细而数，按之无力，则治当固密肾根，亦绝不能发汗。此证，阴来搏阳，阳无力以争则脉数，阳被阴格而证或见发热，阳气已经摇摇欲散，若误以发热为太阳之表，而妄发少阴之汗，必然致成汗出亡阳而变证百出。总之，脉沉细数，无论见于少阴阴虚还是阳虚，均不能再发其汗，否则不是导致竭阴，便是造成亡阳。

“少阴病，脉微，不可发汗”。微主阳虚。少阴病见微脉，是阳气大虚，故不可发汗。妄发阳虚之汗，则必致亡阳而拔少阴之根；若少阴阳气已虚，又见尺脉弱涩，尺以候肾，脉弱涩主精血不足，少阴阴阳俱虚，不仅不能发汗，而且也不能施以攻下，发汗则亡其阳，攻下必竭其阴。由此可知，少阴病虽有大承气汤急下之证，但其尺脉必不弱涩。且如果少阴阳虚脉微、肢厥无汗，不用四逆汤急温，强发少阴阳虚之汗，则必因阳虚不能蒸化津液以作汗，而反动发其经隧之血从空窍出。少阴之脉循喉咙，挟舌本，系目，故血或从口鼻或从目出。出现这种情况，说明阳气厥于下，阴血竭于上，即“下厥上竭”之证，少阴阴阳气血俱伤，所以属于难治之证。

1963年，在山西太原见一慢性肾炎患者，徐姓，女，36岁，已至尿中毒程度，小便点滴而少，口鼻时时衄血，并见呕吐、肢冷、周身浮肿等证。脉沉而欲绝，舌胖而苔白。《伤寒论》少阴病篇所说的“下厥上竭”就是此证。下厥而阳气不化，故小便不得通；上竭而血不摄，则从口鼻出。阴竭于上，阳厥于下，阴阳不相维系而相离决，故为难治之证。虽为疏真武汤加牛膝，但服之无效。患者未满一周即死于尿毒症。

少阴病不但有汗、下之禁，更有以火劫汗之忌。如少阴病见咳而下利，本为寒邪上下之变，即少阴寒邪上逆于肺而作咳，下迫于肠则下利。少阴阳虚里寒，当治以四逆汤温之则愈。若不用四逆汤温里，却用火攻以劫其汗，则不仅竭其肾阴，而且还要耗其胃液，胃燥则谵语，肾燥则小便难，从而发生误火伤阴的坏证，这也需要引起我们的注意。

从少阴病的各种变治方法可以看出，它既有麻黄附子细辛汤的汗法、大承气汤的下法；同时，又有汗、下之法的禁忌，这说明任何事物都是一分为二的。我们只有综合学习，全面掌握，才能相得益彰，以尽其辨证论治的全貌。

（七）少阴病的预后

少阴为生命之根，其病在六经病证中是最为严重的。因此，少阴病的预后在一定意义上来说，关系着病体的生死安危。有关少阴病的预后，在《伤寒论》中论述的较多，且较为真切，是来自于实践的经验总结，具有很强的科学性，当认真学习。

少阴病概括地说，属于阴阳偏衰的病变，但以阳虚的证候为主。少阴阳虚，病情沉重，病势险恶，故治当急温，若稍有疏忽，则有亡阳的危险。要判断少阴阳虚寒证的预后情况如何，主要是看机体阳气的存亡，也就是说“阳存则生，阳亡则死”。

如少阴病中风，即风寒邪气中于少阴经，其脉见“阳微阴浮”，也就是寸微尺浮，寸脉微主邪不盛，尺脉浮是阴病见阳脉，邪气不盛而正气有驱邪外解之机，故“为欲愈”。

少阴伤寒，手足厥冷而脉紧，是寒邪盛而阳气被抑之象。至七八日，邪气入深而见下利，但脉却由紧变微，手足由厥变温，这说明少阴阳气得到恢复，阴寒邪气不能自容，故《伤寒论》中说“脉紧反去者，为欲愈”。此时，患者虽见心烦、下利，正是阳复邪去的表现，与太阴病暴烦下利、腐秽当去有同等意义，一旦邪去尽，则烦利亦必自止。

少阴病虚寒下利，见恶寒、肢体蜷缩而卧，属于阳虚阴盛的恶候。如果下利能自行停止，手足由厥转温，说明寒从利减，阳气来复，此时虽见恶寒身蜷，仍属可治之证。同样道理，少阴病恶寒、身蜷而时有烦热欲去衣被者，也反映了阳气的来复，好像在一派阴寒之中仍有一线阳光，为阳存未绝，故亦为可治之证。

少阴病吐利，若属阳虚阴盛，则必见恶寒、厥逆，而今见“手足不逆冷，反发热”，说明阳气来复，阴寒渐退，为可治之证，病虽重亦不至于死。若因吐利交作，正气暴虚，以致脉搏一时不能接续而脉不至，可灸少阴经的太溪穴七壮，通阳以复脉。

以上介绍的是少阴虚寒证的向愈证、可治证，其预后之所以好，关键在于阴寒退，阳气存而生机在，若与此相反，少阴病恶寒、身蜷而下利不止，手足厥冷不回，呈现一派阴寒病象，说明阳气已亡，失去了自复之机，故预后多不良。如果病情再进一步发展，少阴病，或见厥利，吐逆而烦躁；或见恶寒，身蜷，脉不至，不烦而躁；或见下利不止，冷汗淋漓，烦躁不得卧寐；或见息高作喘，呼吸浅表而不能纳气归根；或下利虽止，而见头眩、时时昏冒等等，这一系列证候反映了阴盛阳亡，精气衰竭，阴阳不相维系而神气外亡；或气绝于下，肾根已拔；或阳绝

阴竭，孤阳无依而上脱，凡此种种，均属危象，视为“死”证。

从以上辨少阴的生死预后，对我们有很大启示，即通过少阴的生证而后知阳气之可贵，通过少阴的死证而后知阴寒之可畏。对于少阴病，只有谨守病机，不失时宜地抓紧救治，或施以扶阳祛寒，或治以滋阴降火，图治于危亡之先，才是防止阴阳竭绝的根本方法。

九、辨厥阴病脉证并治

厥阴病，是伤寒六经病证的最后阶段，为三阴经之末，如《内经》所说“两阴交尽，故曰厥阴”。厥，有极的意思，病至厥阴，则阴寒盛极。但根据辩证法的观点，物极必反，物穷则变，阴阳对立双方发展到极期时可以互相转化。阴寒盛极，则有阳热的来复，也就是阴尽而阳生，寒极则生热。

阴病转阳，寒极生热，是有条件的。这个条件主要是看正邪斗争的状况，其关键取决于人体阳气功能的盛衰。厥阴与少阳相为表里，“厥阴中见少阳”。厥阴、少阳均内寓相火，少阳为一阳之气，标志着阳气的初生，这些就是阴尽阳回的基本条件。由于阴寒盛极，而有阳气来复之机，故厥阴之为病，阴中而有阳，常以寒热错杂的证候出现。又由于阴阳有消长、寒热有胜复，故厥阴病也可以表现为寒证、热证以及阴盛亡阳的死证。

厥阴病的主证，以消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食的寒热错杂证为代表；而厥阴病的阴阳胜复，又常以手足厥冷与发热的日数多少作为判断的依据。厥阴病的寒证，以手足厥冷和下利为主要见证；厥阴病热证，则以口渴、下利后重、呕而发热为主要临床表现。厥阴病主要是肝的病变，肝病则疏泄不利，可以影响脾胃功能不和，因而常见呕吐、啰、下利等疾患。

厥阴病的治法，寒者宜温，热者宜清，而寒热错杂者，当寒温并施兼而治之。

（一）厥阴病辨证纲要

厥阴之为病，见上热下寒的寒热错杂证，正是反映了厥阴阴尽而阳生的病变特点。厥阴为风木之脏，内挟少阳相火，风火相煽，消灼津液，使脏燥无液而求救于水，故见消渴。这里的“消渴”是指渴而能饮、饮而又渴的一种证候，并非多饮多尿的消渴病。厥阴、少阳木火之气上

冲，则见“气上撞心，心中疼热”的证候。热则消谷善饥，寒则运化不利而不能食，“饥而不欲食”是上热下寒、寒热错杂的表现。由于中、下焦虚寒，进食亦不能得到腐熟消化，反致胃气上逆而作吐；若其人内有蛔虫寄生，还会因蛔虫避寒就温、闻食物的气味而上窜，出现吐蛔的证候。既然病属寒热错杂，当治以寒温并用。若只见其热而不见其寒，纯用苦寒之药以泻下，则必更伤脾胃，使下寒更甚，而见下利不止；当然，若只见其寒而不及于热，误用辛热去寒之剂，也会更助上热以灼津，从而使人烦渴更甚。

（二）厥阴病寒热错杂证治

1.乌梅丸证

厥阴病，以寒热错杂证为主要病变。而寒热错杂、上热下寒，若见于有蛔虫寄生的病人，则可表现为吐蛔，并因厥阴疏泄不利，气机不畅，以致阴阳气不相顺接，而见手足厥冷。吐蛔而见厥者，为蛔厥，也就是说吐蛔是蛔厥证的一个必见之证，这与前面讲的由于阳虚阴盛，阳虚不达四末而致的厥逆证有所不同。蛔厥的吐蛔，是因为脏寒，脏寒在这里是指胃肠有寒，肠有寒不利于蛔虫的寄生，蛔虫本能地避寒就温而上下躁动不安，“蛔上入其膈”，则其人心烦不宁；而膈上又非蛔虫久留之地，少顷蛔虫又下行，故其烦复止；若在进食以后，出现心烦、呕恶的，则是“蛔闻食臭出”，因而“其人常自吐蛔”。还有一种叫脏厥的就和蛔厥不同了，其特点是：“脉微而厥。”至七八日，更可见皮肤冷，患者躁动而无暂时安静的时候。这种脏厥证是纯阴无阳，与蛔厥证寒热错杂的病变不同，症状各异，不能混为一谈。蛔厥治以乌梅丸，分治寒热，和胃安蛔。

乌梅丸由乌梅、细辛、干姜、黄连、附子、当归、蜀椒、桂枝、人参、黄柏组成。本方为治厥阴寒热错杂以及蛔厥证的主方。方用乌梅醋浸益其酸，以和肝安胃，敛阴止渴，安蛔缩蛔；用附子、干姜、桂枝温经扶阳以胜寒；川椒、细辛辛辣性热，能通阳破阴，且能杀伏蛔虫；黄连、黄柏苦寒以泄热，并能驱蛔下行以止吐烦；人参补气以健脾，当归补血以养肝。诸药配合，使寒热邪去，阴阳协调，蛔安胃和，气血恢复，是为制方之宗旨。方中虽寒热药物并用，但温热药偏多，又得乌梅酸收敛固，因而可治疗寒热滑脱之久利。用米与蜜甘甜之品为辅料做

丸，不但能养胃气之虚，且可投蛔所好而作为驱虫的诱饵。本方在临床上，现多用作汤剂，对治疗胆道蛔虫症有很好效果。

2.干姜黄芩黄连人参汤证

伤寒本因寒而下利，医者误以为实热而用吐下的方法治疗，从而使里气更虚，气机不利，脾胃升降失常而寒热格拒。胃阳被格而逆于上，则“食入口即吐”；脾阳被抑而清气不升，则下利更甚。

呕吐有寒热之分，一般地说，因于寒者多表现为朝食暮吐，暮食朝吐；因于热者，则多是“食已即吐”。本证食入口即吐，当属热证。但由于这种热是来自于吐下后的寒格，因而热只表现在上，下则还是寒。上热下寒，故吐利交作，宜以干姜黄芩黄连人参汤清上温下。干姜黄芩黄连人参汤，由干姜、黄芩、黄连、人参组成。方用黄芩、黄连以泄上热，用干姜温脾以去寒，人参能健脾补虚。本方寒热并用、苦降辛开，干姜又可引导黄芩、黄连，使热邪不发生格拒，所以，有的注家认为此方也治火逆的呕吐。

3.麻黄升麻汤证

伤寒六七日，寒邪虽然已经化热，但犹未成实，而医者不察虚实，即行攻下，从而使正气受伤，邪气内陷，形成上热下寒、虚实并见的复杂证候。下后，阳邪内陷，郁而不伸，故寸脉由浮数变为沉迟，而下部脉不至；阴阳气不相顺接，故手足厥逆；下后阴阳两伤，寒热错杂，内陷之阳邪淫于上，则为咽喉不利，吐脓血；阳气内虚而不能主持于下，故见泄利不止。此时，阴阳上下并受其病，而虚实寒热亦复混淆不清。此证若治其阴，则必伤其阳；若补其虚，则又碍其实，因此成为难治之证。所谓“难治”，并非不可治，可以麻黄升麻汤寒热兼治，宣发阳郁之邪，滋润肺胃之阴。

麻黄升麻汤由麻黄、升麻、当归、知母、黄芩、葳蕤、芍药、天冬、桂枝、茯苓、炙甘草、石膏、白术、干姜组成。方中麻黄、升麻剂量最大，用以宣发陷下阳郁之邪；用黄芩、石膏以清肺胃之邪热；桂枝、干姜通阳温中以祛寒；当归、芍药养血和阴；知母、天冬、葳蕤滋阴降火以和阳；甘草、茯苓、白术不仅能健脾益气而止泄利，且能安胃

和中而交通上下。此方汇合补泻寒热而成汤，使相助而不相悖，虽用药较多，但不是杂乱无章，为虚实寒热错杂病证而立法，寓有精当的意义。

录陈逊斋医案，供参考：李梦如子，曾二次患喉痰，一次患溏泄，治之愈。今复患寒热病，历十余日不退，邀余诊，切脉未竟，已下利二次，头痛，腹痛，骨节痛，喉头尽白而腐，吐脓样痰夹血，六脉浮、中两按皆无，重按亦微缓，不能辨其至数，口渴需水，小便少，两足少阴脉似有似无。诊毕无法立方，且不明其病理，连拟排脓汤、黄连阿胶汤、苦酒汤，皆不惬意；复拟干姜黄芩黄连人参汤，终觉未妥；又改拟小柴胡汤加减；以求稳妥。继因雨阻，寓李宅附近，然沉思不得寐，复讯李父：患者曾出汗几次？曰：始终无汗。曾服下剂否？曰：曾服泻盐三次，而至水泻频作，脉忽变阴。余曰：得之矣，此麻黄升麻汤证也。患者脉弱易动，素有喉疾，是下虚上热体质。新患太阳伤寒而误下之，表邪不退，外热内陷，触动喉病旧疾，故喉间白腐，脓血交并。脾弱湿重之体，复因大下而成水泻，水走大肠，故小便不利。上焦热盛，故口渴。表邪未退，故寒热头痛、骨节痛各证仍在。热闭于内，故四肢厥冷。大下之后，气血奔集于里，故阳脉沉弱；水液趋于下部，故阴脉亦闭歇。本方组成有桂枝汤加麻黄，所以解表发汗；有苓、术、干姜化水、利小便，所以止利；用当归助其行血通脉；用黄芩、知母、石膏以消炎清热，兼生津液；用升麻解咽喉之毒；用玉竹（即葳蕤）以祛脓血；用天冬以清利脓痰。明日即可照服此方。李终疑脉有败征，恐不胜麻、桂之温，欲加丽参。余曰：脉沉弱肢冷是阳郁，非阳虚也。加参，转虑掣消炎解毒之肘，不如勿加，经方以不加减为贵也。后果愈。

（三）厥阴病寒证

厥阴感寒与阳气衰微是形成厥阴寒证的基本原因，寒为阴邪，易伤阳气，阳虚则生寒，故寒与阳虚常互为因果而致病。

厥阴为阴之尽，故其寒证亦可表现为寒之极。阴盛寒极，阳虚不达四末，致手足厥逆，也是厥阴寒证的一个突出表现。厥阴病篇复举四逆汤及通脉四逆汤证，并以厥逆为必见之证，其道理亦就在于此。如大汗或大下之后，以致阳虚而阴盛，阳虚不充四肢则为厥逆，此时虽无腹痛、下利等证，亦当以四逆汤救阳为急。又如汗出伤阳，阳虚则寒冷内生，血脉凝涩拘挛，因而腹痛下利；四肢为诸阳之本，阳虚不能温养四肢，故不但手足厥冷而且疼痛，说明阳气不仅无内温之力，而且亦无外护之能，仍应以四逆汤温阳退寒。手足厥逆，脉应沉微，方为阳虚之厥；若脉来疾促，按之无力，此乃虚阳与强阴相争，争则脉疾，不胜其阴寒，故手足反厥逆，治疗可先用灸法，如灸太冲穴，通阳以消阴，然后再服四逆汤回阳。若厥阴寒逆作呕，阳虚而又脉弱，其人小便复利而身有微热，是为阴寒内盛而阳气外格之证，如果更见手足厥逆不回的，属于阳虚而寒进，故为难治之证，应急以四逆汤回阳救逆。若厥阴里寒而下利清谷，手足厥冷，里寒极盛，格阳于外，反见身微热、汗出，这是“里寒外热”真阳欲从外脱的险证，当急以通脉四逆汤，摄阳以消阴。上述四逆汤证与通脉四逆汤证均在少阴病篇做过详细介绍，下面根据厥阴病的特点，重点介绍吴茱萸汤证和当归四逆汤证。

1. 吴茱萸汤证

厥阴肝脉，挟胃属肝，上贯膈，布胁肋，循喉咙之后，上入颞颥，连目系，上出与督脉会于巅顶。寒伤厥阴，下焦浊阴之气，循经上犯于胃，致胃寒气逆而干呕、吐出清涎冷沫；上犯于头部，引起巅顶作痛。临床上，人多知有肝阳上亢，而每忽略肝阴上逆，实际两证皆有，只是肝阳上亢较多而已。一般地说，肝阳上亢，多挟风火；肝阴上逆，多挟水饮。厥阴病浊阴上逆而犯阳，故以头痛、吐涎沫为主要表现，治疗用吴茱萸汤暖肝温胃，散寒降逆。

吴茱萸汤证在《伤寒论》中见于三处，涉及阳明、少阴、厥阴三经

病变。从其方证分析，肝胃虚寒是为病变之根本。但既属肝胃虚寒，为什么又列入少阴病中呢？这是因为少阴肾阳为一身阳气之本，元阳之气根于肾，由肝胆而升，行于三焦，温煦各个脏腑组织，因而肝胃虚寒不能与少阴无关。再者，胃为中土，乃少阴心肾水火相交的必由之路，若胃气虚寒，升降失常，则心肾水火亦不能正常地交通，从而形成少阴病。为此，少阴病之烦躁欲死，是心肾不交的见证，又是阳与阴争的反映。

2.当归四逆汤证

厥阴肝主藏血，若血虚受寒，寒滞肝脉，阳气不达四末，而见手足厥寒的，则属当归四逆汤证。以脉辨证，微主阳虚，细主血弱。阳虚阴盛而见手足厥冷，则脉必微；而血虚肝寒见手足厥冷，则脉必细。脉为血之府，血虚寒滞，血脉不充，细涩不利，故脉细而欲绝。厥阴血虚有寒，治宜补血通经散寒，用当归四逆汤。

当归四逆汤由当归、桂枝、芍药、细辛、炙甘草、通草、大枣组成。方用当归、芍药补肝养血以调营，桂枝、细辛通阳疏肝以散寒，甘草、大枣补脾胃而和中，通草通阴阳以利血脉。少阴为病，重在阳虚，故四逆汤用姜、附以扶阳；厥阴为病，重在血虚，故四逆汤用归、芍以养血。四逆汤药少力专，回阳宜急；本方药多义广，善能温通血脉。若内有久寒，表现为下焦积冷，少腹冷痛，或中焦寒饮呕吐、脘腹疼痛，可加吴茱萸、生姜以暖肝温胃，散寒饮。本方用清酒煎药，借以增强其温通散寒的力量。

白某，女，28岁。在田间劳作，适值月经来潮，因入野厕，自觉寒风吹袭下体，非常冷冽。不久病发少腹冷痛，腰痛如折，不可忍耐。曾服独活寄生汤无效。其脉弦细，舌苔白润，此乃经期风寒入客，络脉瘀滞而为病。为疏：

当归12克，桂枝12克，赤芍9克，细辛6克，通草6克，石楠藤12克，鸡血藤12克，大枣7枚。

仅服二剂则病愈。

（四）厥阴病热证

厥阴病有寒证，亦有热证。厥阴之寒，是感受寒邪而阳气不足；厥阴之热，是感受热邪或阳气被郁，属于真热，并非虚阳外浮之假热。厥阴热证有厥阴之邪，外出少阳，由阴转阳，见呕而发热的小柴胡汤证；有因于邪热深伏，阳郁不伸而格阴于外，见脉滑而厥的白虎汤证；有腹胀满、下利、谵语，大肠有燥屎的小承气汤证；亦有下列后，余热不尽蕴郁胸膈，“按之心下濡”的虚烦证。以上各种病证已分别在有关篇章作了介绍，这里就不再重复。

若厥阴病虚寒下利，而转见脉数、口渴，说明阳热来复，正能胜邪，疾病有自愈的机转。如果脉数不解，口渴不除，则是阳复太过，热气有余。厥阴化热，肝不疏泄，以致气滞壅塞，湿聚热灼，津被热伤，血被热腐，湿热下迫，不仅见口渴，而且可见下利便脓血之证。由于湿性黏滞而热性急迫，故湿热下迫大肠，必以里急后重，便脓血黏液为其特点。厥阴湿热下利，当治以白头翁汤清热燥湿，凉血疏肝。

白头翁汤由白头翁、黄柏、黄连、秦皮组成。白头翁味苦性寒，擅清肠热而治毒痢，且能疏达厥阴肝木之气；黄连、黄柏清热燥湿，厚肠胃以止利；秦皮苦寒，能清肝胆及肠道湿热，凉血以坚阴。本方具有清热燥湿，疏肝凉血的作用，故对下重、便脓血之热性痢疾有很好疗效。

姜某，男，17岁。入夏以来腹痛下利，日六七行，后重努责，下利急而排便不出，再三努力，仅少许脓血黏液而已。口渴思饮，六脉弦滑而数，舌苔黄腻。此厥阴下利，湿热内蕴，肝不疏泄，如唐容川所说“金木相诊，湿热相煎”之证。

为疏：白头翁12克，黄连、黄柏各9克，秦皮9克，滑石块18克，白芍12克，枳壳6克，桔梗6克。

服二剂，大便次数减少而下利已除；又服二剂，大便不带黏液，唯腹中有时作痛，转用芍药汤二剂而愈。

厥阴虚寒下利，脉当沉迟，“若寸脉反浮数，尺中自涩者”，说明阳复太过，下乘不足之阴，阴虚热炽，血为热腐，亦可见便脓血。寸脉为阳，浮数亦为阳，寸脉浮数，反映了阳热有余；尺脉为阴，尺中见涩脉，反映了里阴不足。强阳煎灼弱阴，亦有便脓血之患。但此属热炽阴伤而便脓血，自与湿热下重的便脓血不同，《伤寒论》中未提出治法，可考虑用黄连阿胶汤滋阴降火以治之。

（五）厥阴病的病机进退

病至厥阴，阴尽而阳生，由于正邪斗争有胜负，故其病变有厥热进退的机转。

伤寒从一二日至四五日，处于正邪交争、阴阳消长的阶段，其斗争结果，如果阳热内盛而格阴于外，以致阴阳气不相顺接，便可形成手足厥冷的热厥。热厥的特点是发热在前，手足厥冷在后，且手足厥冷的程度还要随里热的深浅、微甚而增减，也就是“厥深者热亦深，厥微者热亦微”。热厥是由邪热内陷，阳郁于里不能达于四末所致，故在厥热的同时，必兼见烦渴、不大便等证。此证治疗当以泻下剂，破阳行阴，使邪热得去，阴气得伸，厥热自解。若反用辛温发汗法以解热，必更助邪热而炎于上，出现口腔溃疡烂赤之证。

伤寒阴盛阳衰，阳虚不达四末，亦可致手足厥冷。但如果厥发五日，而后又发热五日，说明阴寒虽盛，而阳气又得以恢复，正与邪争，各不示弱。假使第六日，阴当复胜又见厥，可是其人并不出现厥逆，预示病当自愈。因为厥与热反映了机体的阴阳消长，厥五日热亦五日，厥热相等，无太过亦无不及，阴阳平衡，故其病自愈。在伤寒的病变过程中，正邪斗争，厥热胜复，其病机进退的关键取决于阳气的盛衰状况。若厥热交替，发热为四日，厥逆只三日，而复热又四日，此厥比热少，阳胜阴退，故其病亦当愈；反之，若厥四日，热反三日，后又复厥五日，为寒多热少，主阳不胜阴，阳气退而阴气进，标志着病情将发展；若阳气来复，四日至七日发热不退，说明阳复太过化热而将伤阴，如灼伤阴血，其后必有便脓血之患。同样道理，伤寒见厥逆、下利，属阳虚阴盛，若由于阳气来复而后见发热，则不但厥回，而且下利亦必自止，这是阳长阴消、阳进阴退，疾病由阴转阳的欲愈之象；假设发热后又见厥冷，说明阳退阴进，阴寒用事，则还要出现下利。可见伤寒厥逆，如后见发热，标志着阳气来复，疾病有向愈的转归，但阳复应以平和为宜，如果阳复太过，也会致成邪热为病。邪热蒸于外、炎于上，逼迫津液外泄则反汗出，熏灼咽喉则病喉痹；若发热无汗，阳热不得外泄而迫于里、趋于下，则热伤下焦血分而发生便脓血的病证。由于邪热下行而不上逆，故病便脓血者，就不再病喉痹肿痛。

厥热胜复，反映了正邪斗争，阳气盛衰的状况，故可作为判断厥阴病机进退的一个重要标志，但它不是唯一的标志，从患者能食与不能食、脉数与脉迟，同样亦可了解病机的进退出入。如伤寒开始发热六日，后又见厥逆，下利九日，若厥逆属于阴寒内盛者，患者当不能食而脉迟；如果其人反能食，则“食以索饼”，即面条一类的食物，食后不发暴热只见微热，说明是阳气来复而胃气尚在，并不是除中。“除中”是胃气败绝的一种证候。胃热则消谷能食，胃气虚寒则不能食，而胃气败

绝、虚阳欲脱之际，患者亦可出现能吃东西的反常现象，但进食后患者常突发暴热随之即去而死，死于中气消除，故名“除中”。今食后三日不见暴热，而见微热持续存在，属于阳气来复的佳象，当于三日期满时病愈。其病愈的道理，是本发热六日，厥反九日，后又续发热三日，并前之六日亦合计为九日，厥与热相应，阴阳均衡，故其病当愈。若三日

后，其热当止而不止，脉又见数，则主阳复太过，热气有余，若进而腐灼阴血，又必然发生痈脓之变。

厥热相应，其病主愈，已如上述。若邪微而不甚，正复而不过，则其病亦向热少厥微愈。如寒微，仅表现为手指头寒，烦躁数日后，小便由短赤转为通利色白，由默默不欲食转为欲得食，说明邪气本不盛，入里亦不深，正邪斗争的结果，使邪热除、胃气和，故知其病当愈；若不是这样，其人表现为手足厥冷、胸胁满、心烦、多呕、小便红赤，则反映了肝胆气郁，阳复太过而里气不和，如病情再进一步发展，恐热伤阴络终发生便血之证。

从以上所论述的厥热胜复病变可以看出：凡先热后厥的，多属传经之证，其病机进退主要取决于邪热出入、浅深；而先厥后发热的，则多属直中之证，其病机进退主要取决于机体的阳气盛衰，阴阳胜复。气有所胜，必有所复，凡寒胜者必兼下利与不能食，凡热复者必挟伤阴与动血。因厥阴属肝，肝主藏血，故肝热伤阴，常有动血之患。同时也可看出，厥阴病从厥热多少，以辨阴阳进退、寒热盛衰，临床虽未有此典型病例，但以此来推论阴阳消长，作为诊断病情和预示疾病转归的依据，还是有其现实意义的。然如果仅就厥来说，虽有阳虚阴盛之寒厥与阳郁格阴之热厥的不同，但其证表现为手足厥冷则一，其病机又均可以阴阳气不相顺接加以概括，所以《伤寒论》指出：“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷是也。”可称为要言不烦了。

（六）厥阴病治疗禁忌

厥逆证，是厥阴病的主要见证之一。伤寒病至厥阴，多致阳微而阴盛，此时见手足甚或四肢厥冷者，只能治以温经回阳，绝不能用苦寒泻下，《伤寒论》中说“诸四逆厥者，不可下之”即指此而言。不仅阳虚致厥者不能用下法，血虚而见厥者同样亦不能用下法。如伤寒五六日，邪气传里之时而见厥，但不见结胸证，腹部按之濡亦不见腑实证，脉按之又虚，这是血虚不荣四末的厥证，因而不能用下法。如误下，则犯“虚

虚”之诫，甚或导致正气虚脱而死亡，因此我们一定要高度警惕，不可疏忽大意。

（七）厥阴病预后

病至厥阴，可以说是疾病发展到了最后阶段，因此，判断厥阴病的病势微甚以及生死预后转归，就显得尤为重要。在厥阴病篇中，有关预后转归的内容甚多，由于在厥热胜复一节里已有所涉及，这里不再重复。下面再将其他的一些有关预后的内容作概括介绍。

厥阴病中风也好、伤寒也好，都属于阴经受邪，病变在里，故其脉应以沉微为多见，若脉沉转为微浮之脉，说明里邪外出，是阴病见阳脉，所以说“为欲愈”。若脉不见微浮而仍沉，则表示邪气内伏于里，故其病“为未愈”。太阴病中风，脉阳微阴涩而长者，为欲愈；少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈；而厥阴中风又以脉微浮者为欲愈，可见凡阴病见阳脉，均是疾病向愈的好现象。

下利是厥阴病的常见证之一，其性质如何，预后又怎样，亦可以脉象变化来推断。若伤寒下利，日十余行，邪未尽而正已大虚，其脉当微弱，方得为顺，若脉反实，是正气虚而邪气有余，邪实不为下利所衰，正不胜邪，故主预后不良；脉见沉弦，沉为在里，弦为肝脉，湿热蕴结于里，厥阴肝木疏泄不利，故当见下利后重，大便不爽有黏液；若脉大者，大则病进，是邪气仍盛，故为下利未止；若相反，脉见微弱数者，说明阳热之邪已退，真阴之气将复，故下利将自止，此时虽有发热，亦不至于死，因为邪气已衰，正气已复。如因寒下利，而见微热、口渴、脉弱，是寒去而阳复之象，故可不治而自愈；若下利脉数、有微热、汗出，标志着阴邪退而阳气得通，故亦不治自愈；但如脉又复紧，说明里寒又盛，故主病未解；下利脉数而渴，是为阴去阳复的自愈之象，若不愈，则可因阳复太过而化热伤阴动血，发生便脓血的证候；虚寒下利，至手足厥冷而无脉，是阴先竭而阳后绝，或用灸法，或用温剂以急救其阳，急复其脉，如二十四小时内（即晷时）脉还而手足转温者，是真气未亡，生机尚在，故主生；若脉不还，则是真气亡而不能续，故主死；若经灸法治疗后，不仅厥不回、脉不还，而且更见微喘者，是为真气不续，大气下脱，故亦主死。

厥阴病的厥热胜复，反映了正邪斗争、邪正盛衰的状况，故对判断预后很有价值。一般来说，厥热相应，或厥少热多，或热少厥微，都是

疾病自愈的好现象；若发热而后见厥，是寒邪复胜，至七日，当正气欲复、邪气欲退之时，更见下利的，说明正不复而邪反进，属于难治之证；伤寒见发热，阳复而阴退，厥利当自止，若厥利不止，更见躁扰不宁、不得卧寐者，则是阴盛阳亡，神气散乱之象，预后不良；若伤寒发热而下利至甚、厥逆不止，是阴竭于内而阳亡于外，虽不见躁不得卧，则亦会因阴的竭绝而死；若始病不见下利，至六七日后，发热与下利俱见，此热亦非阳复之热，乃阴盛格阳之象，若更见汗出不止，则是阳气不固而外脱，最后形成了“有阴无阳”的状态，“阴阳离决，精气乃绝”，故亦为死证。

综上所述，可见阴阳之道以平和为顺，偏盛偏衰则为病，阴阳离决则致人死。医生的责任，就是要把握疾病的发生发展规律，从而有效地防治疾病。为此也就必须了解阴阳的对立统一规律，做到顺其情理，不断地进行调整，而使之和平。限于历史条件和科学水平，《伤寒论》中特别是厥阴病篇提出了一些“死”证和“不治”之证是可以理解的，但我们也不能宥于古人之言，放弃救死扶伤的责任，应该充分利用现代的医疗条件，采取中西医各种有效的方法，积极主动地进行救治。大量的临床实践也有力地证明，古时的不治之证，今天则已不断成为可治之证。相信随着医学科学的发展，今后将有更多的不治之证获取有效的防治方法。

十、辨霍乱病脉证并治

霍乱是以上吐下泻为主要临床表现的暴发性的胃肠疾患。霍有挥霍、急骤的意思，乱有撩乱、变乱的意思。本病因来势急，吐泻剧，故取名霍乱，非专指因感染霍乱弧菌所引起的霍乱。

霍乱病，多因饮食不洁，或暴饮暴食，或感受六淫邪气，而使表里之邪相并，寒热错杂，乱于肠胃，清浊相干，升降失常所致。

后世医家根据证情不同，又把霍乱分为干霍乱和湿霍乱两大类：脘腹绞痛，欲吐不能吐，欲泻不能泻者为干霍乱；吐泻交作而无度者为湿霍乱。本篇所述之霍乱，因以吐泻为主症，故属湿霍乱。因本病有与伤寒类似之处，故在六经病证之后设霍乱篇，以与伤寒病作鉴别。

（一）霍乱病辨证纲要

霍乱是以邪气乱于肠胃，清浊相干，升降失常为主要病变，故其病以猝然发作的上吐下泻为辨证依据。论中所谓：“呕吐而利，此名霍乱”，“霍乱自吐下。”都揭示了霍乱的证候特征。

（二）霍乱与伤寒的鉴别

由于霍乱亦由感受外邪所引起，并在初起常伴有表证，见发热、头痛、身疼、恶寒等症状；而伤寒邪气自表传里、由阳转阴之时，亦可见吐利等症，故这两种病证需要加以鉴别。

霍乱多是六淫邪气与饮食所伤合并乱于肠胃，病自内发；伤寒则是外邪客表，由皮毛而入，其病自表向里传变。正因为这两种病在病因、病机、病变过程几个方面均有所不同，故二者在脉证上就有明显的区别：霍乱起病即见上吐下泻，而且吐泻势重；伤寒则只有在邪气由表传

里，由阳转阴的时候才见吐利，而且其病势亦多较缓和。霍乱吐利交作，津气大伤，故初起即见脉微涩；伤寒初起病在表，正气抗邪有力，故脉浮紧。论中所说：“霍乱自吐下”，“伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日，至阴经上，转入阴必利。”既指出了霍乱的证候特点，也阐明了其与伤寒的鉴别要点。

（三）霍乱病的证治

1.霍乱表里寒热证治

骤然间发作上吐下泻，并兼有头痛、发热、身疼痛等症，是霍乱兼有表邪，属表里同病。其中若表现为发热多、口渴欲饮水而小便不利的，为表邪重，水蓄膀胱，气化不利之证，当治以五苓散，表里两解，通阳化气，升清降浊；若恶寒重、口不渴者，为寒湿邪困，则治宜理中汤、丸，温化寒湿。

2.霍乱吐利亡阳证治

霍乱既吐且利，吐利交作，必然大伤阳气。阳气虚不能温煦肢体，所以手足厥冷、四肢拘急而恶寒；不能固护肌表、敛摄津液，所以大汗出；无力鼓动血脉，所以脉微欲绝。阳虚阴盛而格阳于外，所以还可见内寒外热的真寒假热证。本证虽因吐泻亦有津液耗损，但仍以阳气亡脱为急为重，故治以四逆汤急救回阳。

3.霍乱吐利阴阳两虚证治

霍乱吐利，气随津泄，遂使阳虚。阳虚不能温化水谷，摄敛津液，又致泄利不止。越是下利，则阳越虚，阴益伤。若利虽止，而恶寒脉微不得缓解者，是阳亡液脱，津液内竭，无物可下之征，即所谓“利止亡血也”，当急用四逆加人参汤回阳救阴，益气生津。

四逆加人参汤由四逆汤加人参组成。方用附子、干姜、炙甘草回阳

救逆，加人参益气生津。

4.霍乱吐利阳亡阴竭证治

霍乱病吐利停止，可见于两种情况：脉复肢温者，属阳回阴消为欲愈；若“吐已下断”，指无物可吐，无物可下，手足厥逆不回，四肢拘急不解，汗出而脉微欲绝者，是属吐利之后而使阳气虚脱、阴液竭绝的危重证候，其治当用通脉四逆加猪胆汁汤，回阳益阴。

通脉四逆加猪胆汁汤用通脉四逆汤破阴回阳救逆，猪胆汁苦寒性润，一可润燥滋液而比人参为速，以补吐下后津液之枯竭，又可制约姜附辛热伤阴劫液之弊；同时，还可借其性寒走下，引姜附大辛大热药物入阴，以防阴气过强对辛热药物的格拒。

5.霍乱病后的调治

霍乱吐利停止，若不见阳亡阴竭之证，说明里气调和，此时如仍身痛不休，当考虑是表不解，可斟酌具体病情，用桂枝汤小小和解其外。霍乱病后，虽吐利已止，但阴液、阳气已经受损，正虚不耐攻伐，故即使需要发汗解表，也不可用麻黄汤类之峻剂，这是必须要注意的。

霍乱吐泻之后，或虽吐泻未止，又经发汗，脉已转向平和，说明大邪已去，机体阴阳表里趋于平和，是为欲愈的象征。此时如患者见微烦不适，多是霍乱吐利之后，其人脾胃气弱，进食而不能消化所致。《伤寒论》说：“新虚不胜谷气故也。”就讲出了这个道理。此证不需用药治疗，只要能节制饮食，注意饮食调养即可恢复。

十一、辨阴阳易差后劳复病脉证并治

本篇介绍了两部分内容：一是伤寒病人，在病未愈或初愈时，因不慎房事所引起的阴阳易病的辨证与治疗；另一是伤寒病初愈，正气未复，阴阳未平，由于饮食起居失调等原因所引起的诸多病证的辨证与治疗。说得具体一点，差后诸证包括因余邪未尽而病者；正气虚弱而病者；也有因调护失当引起的病证，如食复、劳复等。上述诸病证，证情各有不同，故当随其证而施治。

（一）阴阳易证治

阴阳易病是指男女在伤寒病将愈未愈之时，由于犯房事而引起的一种疾病。伤寒病后，正气本已亏虚，若不节制房事，不仅使精气更伤，而且会引发邪热直伤阴分，从而发生身体重、少气、少腹里急或引阴中拘挛、热上冲胸、头重不欲举、目眩生花、膝胫拘急等证候。论中提出用烧裨散治疗。

（二）差后劳复证治

伤寒是属大病。大病新差，由于真元大伤，在气血未复，余热未尽之时，只宜静心休养，不可妄动作劳。如不很好静养，或多言多虑劳其神，或早作早行劳其力，皆可导致疾病复发。《素问·生气通天论》谓：“阳气者，烦劳则张。”劳神或劳力使阳气浮动，则生烦热，是谓劳复。劳复发热，乃阳热从内向外发作，故治宜宣泄，用枳实栀子豉汤宽中行气，清宣膈热。

枳实栀子豉汤由枳实、栀子、香豉组成。方中用枳实宽中行气，栀子清热除烦，香豉透邪散热。以清浆水煮药，取其性凉善走，调中健胃。

伤寒病变过程中，多累及脾胃，故病后劳复证常伴有消化功能障碍，而表现有食滞纳呆，脘腹胀满，舌苔厚腻等症。若更兼宿食不化，或差后因饮食不节而致复发热者，即所谓食复证，则可用枳实栀子豉汤加大黄荡涤肠胃，推陈致新。

（三）差后复发热证治

伤寒差已，或因劳复，或因食复，或因重感外邪，而又致发热者，当随证施治。若脉浮，表明邪在表，可用汗法治疗；若脉沉实，为邪结在里，可用下法治疗；若在半表半里，属少阳枢机不利者，可用小柴胡汤和解。鉴于小柴胡汤具有和表里、利枢机、扶正去邪的治疗作用，故对伤寒病愈后所出现的一般发热证，均可用此方治疗。

（四）差后腰以下有水气证治

伤寒大病差后，腰以下仍有水气，可见于两种情况：一是伤寒表邪已解，但里之水邪凝聚不除；另一是伤寒病虽愈，但宿疾顽症水气病仍在。不论属哪种情况，只要是腰以下有水气，必见小便不利、脉沉，或可见下肢肿、腹水等症，其治可用牡蛎泽泻散软坚散结，利尿逐水。

牡蛎泽泻散由牡蛎、泽泻、瓜蒌根、蜀漆、葶苈、商陆根、海藻组成。方用牡蛎、泽泻、海藻软坚利水，葶苈宣肺泄水，商陆逐水之结，蜀漆祛痰逐水，瓜蒌根生津散结，使水去而津液不伤。本方既可用散剂，亦可用汤剂。用散剂者，需以米汤调服，其意在于保胃气。服药后见小便利，为水邪去除之象，即可停药。《金匱要略》曾对水气病提出治法，即“诸有水者，腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗乃愈”。本方用于治疗腰以下有水气，正是上述法则的具体运用。

（五）差后喜唾证治

伤寒大病之后，肺脾阳气受伤，不能温化输布津液，凝聚成饮而上泛，从而形成其人喜唾、久不了了的病证。因证属虚寒，故多唾清水，

并伴有口不渴，手足不温，舌淡苔白，脉弱无力等症，治用理中丸温中散寒。因病久不愈，故用丸剂缓缓图之。

（六）差后虚羸少气欲吐证治

伤寒病解之后，虽大邪已去，但正气亦伤，津气亏虚，余热不尽，胃失和降，则其人见形体虚弱消瘦，少气不足以息，食少纳呆而欲吐，以及发热，心烦，舌红苔少，脉细数等症，治用竹叶石膏汤清热、养阴、益气、和胃。

竹叶石膏汤由竹叶、石膏、半夏、人参、甘草、粳米、麦门冬组成。方用竹叶清热除烦、降逆止呕，石膏清肺胃气分之热，麦冬滋阴生津，人参、甘草、粳米益气生津，半夏和胃降逆。本方从药味组成看，可以说是由白虎加人参汤加减化裁而来。竹叶石膏汤证与白虎加人参汤证作比较，二者虽都有气阴两伤，但由于白虎加人参汤证仍以热盛邪实为主，故用知母重在清热驱邪；而竹叶石膏汤证则以虚羸少气为主，故用麦冬重在益阴补虚。

（七）差后日暮微烦证治

病人脉已解，说明大病已去。此时见日暮微烦，多是因病后正气未复，脾胃气弱，消化功能低下，以致食滞难消所引起。此证无需治疗，只要节制饮食即可，论中所说：“损谷则愈”就是这个意思。

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编
■ 刘渡舟 著

第十辑

现代著名老中医名著重刊丛书

刘渡舟医书七种

伤寒论 十四讲



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·第十辑
刘渡舟医书七种

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编



伤寒论 十四讲

著者 刘渡舟

人民卫生出版社

版权页

图书在版编目（CIP）数据

伤寒论十四讲 / 刘渡舟著. —北京：人民卫生出版社，2013. 9

（现代著名老中医名著重刊丛书. 第10辑. 刘渡舟医书七种）

ISBN 978-7-117-17353-7

I. ①伤... II. ①刘... III. ①《伤寒论》—研究 IV.
①R222.29

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第120940号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购
书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

现代著名老中医名著重刊丛书（第十辑）

刘渡舟医书七种

伤寒论十四讲

丛书主编：王庆国 刘燕华

著 者：刘渡舟

出版发行：人民卫生出版社有限公司
人民卫生电子音像出版社有限公司

地 址：北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编：100021

E - mail: ipmph@pmph.com

制作单位：人民卫生电子音像出版社有限公司

排 版：人民卫生电子音像出版社有限公司

制作时间：2019年4月

版本号：V1.0

格式：mobi

标准书号：ISBN 978-7-117-17353-7

策划编辑：李丽

责任编辑：李丽

打击盗版举报电话：**010-59787491** E-mail: **WQ@pmph.com**

注：本电子书不包含增值服务内容，如需阅览，可购买正版纸质图书。

刘渡舟医书七种编写委员会

主 编 王庆国 刘燕华

副主编 李宇航 梁永宣

编 委（以姓氏笔画为序）

于博睿 马小娜 马春雷 王 冬 王庆国

王国华 王利敏 王雪茜 刘 敏 刘丹彤

刘晓倩 刘晓辉 刘燕华 闫军堂 许仲宁

孙 燕 孙良明 孙晓东 李 欣 李成卫

李宇航 李丽娜 李晓莉 李鹏英 吴范武

张 欢 张 娜 张雪亮 陈 明 陈 萌

畅洪昇 周 刚 郑丰杰 房克英 屈会化

赵 妍 赵 琰 赵伟鹏 赵宇明 钟相根

贾春华 倪 磊 高 飞 郭书文 梁永宣

程发峰 傅延龄 鲁 艺 赛佳洋

学术秘书 闫军堂

出版说明

自20世纪60年代开始，我社先后组织出版了一些著名老中医经验整理著作，包括医案、医论、医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国现代中医学术的发展发挥了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显。这些著名老中医在我国近现代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。他们的著作多成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前。无论是亲自撰述，还是口传身授，或是由其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华。诸位名老中医不吝秘术，广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，今已很难见到，部分著作甚至已成为中医读者的收藏珍品。为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将部分具有较大影响力的名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》并分辑出版，以飨读者。

第一辑 收录13种名著

- | | |
|-------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |
| 《钱伯煊妇科医案》 | 《朱小南妇科经验选》 |
| 《赵心波儿科临床经验选编》 | 《赵锡武医疗经验》 |
| 《朱仁康临床经验集——皮肤外科》 | |

《张赞臣临床经验选编》

第二辑 收录**14**种名著

《中医入门》

《章太炎医论》

《冉雪峰医案》

《菊人医话》

《赵炳南临床经验集》

《刘奉五妇科经验》

《关幼波临床经验选》

《女科证治》

《从病例谈辨证论治》

《读古医书随笔》

《金寿山医论选集》

《刘寿山正骨经验》

《韦文贵眼科临床经验选》

《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑 收录**20**种名著

《内经类证》

《金子久专辑》

《清代名医医案精华》

《陈良夫专辑》

《清代名医医话精华》

《杨志一医论医案集》

《中医对几种急性传染病的辨证论治》

《赵绍琴临证400法》

《潘澄濂医论集》

《叶熙春专辑》

《范文甫专辑》

《临诊一得录》

《妇科知要》

《中医儿科临床浅解》

《伤寒挈要》

《金匱要略简释》

《金匱要略浅述》

《温病纵横》

《临证会要》

《针灸临床经验辑要》

第四辑 收录**6**种名著

《辨证论治研究七讲》

《中医学基本理论通俗讲

话》

《黄帝内经素问运气七篇讲解》

《温病条辨讲解》

《医学三字经浅说》

《医学承启集》

第五辑 收录**19**种名著

《现代医案选》

《泊庐医案》

《上海名医医案选粹》

《治验回忆录》

《内科纲要》	《六因条辨》
《马培之外科医案》	《中医外科证治经验》
《金厚如儿科临床经验集》	《小儿诊法要义》
《妇科心得》	《妇科经验良方》
《沈绍九医话》	《著园医话》
《医学特见记》	《验方类编》
《应用验方》	《中国针灸学》
《金针秘传》	

第六辑 收录**11**种名著

《温病浅谈》	《杂病原旨》
《孟河马培之医案论精要》	《东垣学说论文集》
《中医临床常用对药配伍》	《潜厂医话》
《中医膏方经验选》	《医中百误歌浅说》
《中药炮制品古今演变评述》	《赵文魁医案选》
《诸病源候论养生方导引法研究》	

第七辑 收录**15**种名著

《伤寒论今释》	《伤寒论类方汇参》
《金匱要略今释》	《杂病论方证捷咏》
《金匱篇解》	《中医实践经验录》
《罗元愷论医集》	《中药的配伍运用》
《中药临床生用与制用》	《针灸歌赋选解》
《清代宫廷医话》	《清宫代茶饮精华》
《常见病验方选编》	《中医验方汇编第一辑》
《新编经验方》	

第八辑 收录**11**种名著

《龚志贤临床经验集》	《读书教学与临症》
《陆银华治伤经验》	《常见眼病针刺疗法》
《经外奇穴纂要》	《风火痰瘀论》

《现代针灸医案选》

《小儿推拿学概要》

《正骨经验汇萃》

《儿科针灸疗法》

《伤寒论针灸配穴选注》

第九辑 收录11种名著

《书种室歌诀二种》

《女科方萃》

《干祖望医话》

《名老中医带教录》

《班秀文妇科医论医案选》

《疑难病证治》

《清宫外治医方精华》

《清宫药引精华》

《祝谌予经验集》

《疑难病证思辨录》

《细辛与临床》（附 疑难重奇案七十三例）

第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）

《伤寒论十四讲》

《伤寒论通俗讲话》

《伤寒论诠解》

《新编伤寒论类方》

《经方临证指南》

《金匱要略诠解》

《肝病证治概要》

这些名著大多于20世纪60年代前后至90年代后在我社出版，自发行以来一直受到广大读者的欢迎，其中多数品种的发行量达到数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床诊疗水平和促进中医事业发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时尽可能保持原书原貌，只对原著中有欠允当之处及疏漏等进行必要的修改。为不影响原书内容的准确性，避免因换算等造成的人为错误，对部分以往的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的临床检测项目与方法等，均未改动，保留了原貌。对于原著中犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社

2013年3月

整理说明

刘渡舟是北京中医药大学已故终身教授、《伤寒论》专业首批博士生导师，当代著名的中医学大家、中医教育家。刘老行医、执教半个多世纪，上溯岐黄之道，下逮诸家之说，力倡仲景之学，博采众长，学验宏富，形成了鲜明的学术思想和医疗风格，被誉为“伤寒泰斗”、“经方大家”，日本汉方界更称其为“中国治伤寒第一人”，其学术成就为中医同仁所公认，在中医学界享有盛誉。刘老以振兴中医、培育桃李为己任，在繁忙的医疗、教学、科研之余，坚持著书立说，笔耕不辍，培养后学。刘老一生著述颇丰，曾出版中医学术著作20多部，发表学术论文100余篇，为传承中医药事业作出了杰出贡献。

20世纪80年代，刘老的学术经验日臻成熟与完善，在当时十多年的时间里，他出版了数十部关于《伤寒论》、《金匱要略》及经方运用的研究专著，具有很高的学术水平和临床应用价值，深受广大读者欢迎，在中医学界产生了很大的影响，对于推动仲景学术发展和提高中医临床水平起到了重要的作用。为了系统总结刘老的学术思想和医疗经验，并从中窥探其治学方法与道路，我们精选了最能反映刘老治伤寒、用经方、精临证的学术著作，经撰次整理，辑而成帙，名为《刘渡舟医书七种》，付梓再版，以飨读者。这7本代表性医书分别是《伤寒论十四讲》、《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论诠解》、《新编伤寒论类方》、《经方临证指南》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》。这些著作能突出反映刘老之方证相对论、辨证知机论、古今接轨论、气机论、攻邪论、水火论、湿证论、脾胃论、肝胆论以及抓主证等学术思想及其对经方的运用经验，汇集了刘老行医50余年的学术经验和心血结晶，贯彻了理论和实践相结合的方针。通过阅读刘老文稿，读者可窥其学术思想和临床经验之一斑，并有助于系统地掌握刘老的临证特色和诊治经验。编撰者也希望通过这些文字笔墨展示经方大家刘渡舟教授的学术经历及成就，使一代名家为中医药事业不屈不挠的奋斗精神、人格品质及宝贵经验得以传世后人，为中国医学史树起一座不朽的丰碑。

为了使读者能原汁原味地阅读刘老著作，本次修订再版《刘渡舟医

书七种》时，采取尽可能保持原书原貌的原则，除对原著中出现的文字、标点错误稍加更正，并在不影响文意的前提下润色语句不通顺之处外，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排，从而规范了原书的体例层次。而对原书中出现的古今字、异体字、繁简字以及以往的病名、药名、计量单位等，均未改动，保留了原貌。

2007年，为了整理、挖掘、继承和抢救京城名老中医的学术经验，北京市中医管理局启动了“名老中医药专家学术思想抢救挖掘与优秀传承人才培养联动工程”（简称“薪火传承3+3工程”），目的在于做好首都名老中医学术思想的抢救、整理和挖掘工作。刘渡舟名家研究室

（No.2007-SZ-A-09）于2007年10月首批获北京市中医管理局批准，2008年1月授牌，2008年6月正式启动建设，进行了大量卓有成效的工作。将刘老积累多年的学术著作、文章、讲稿等整理、汇编、出版更是研究室的重要工作之一，本书即是在研究室全体成员的共同努力之下完成的，在此，谨向名家研究室这一名老中医学术经验平台的发起者——北京市中医管理局致以崇高的敬意。同时，也向所有参与此次编撰工作的各位同仁致以谢意。

刘渡舟名家研究室主任
北京中医药大学副校长，教授、博士生导师
王庆国
2012年12月

再版序

昔日严器之曾说：“《伤寒论》十卷，其言精而奥，其法简而详，非寡闻浅见所能赅究。”可见研究伤寒之学亦非易易。然而，自成聊摄依经以开注述之端，方中行又“订正”叔和撰次之文，而立三纲鼎立之论，从此而往，名贤辈出，代不乏人，使伤寒之学万紫千红，而蔚成大观。余不敏，伏膺仲景之学有数十年之久，每于研读所获，或临床有得，辄整理成文，而公之于世。年久所积，约十万言，于一九八二年，乃以《伤寒论十四讲》之名问世。一年来，此书销售已尽，索书者仍络绎不绝，因而再版，以满足读者的要求。

再版的内容，除校定书中错字、衍文、遗漏之处和在第一讲内补充了《六经析疑》、《论八纲辨证与六经辨证的关系》外，余之如旧。新补充的两篇文章，对于澄清“六经”中的一些模糊认识是有现实意义的。限于个人水平，其中错误难免，尚希读者不吝批评指正。

刘渡舟
1984年5月1日于北京

前言

我编写的这本小册子，专题讲述了《伤寒论》里的十四个问题。但这些问题并不是孤立存在的，而是有它的系统性和彼此的内在联系。例如，第一讲阐述了《伤寒论》的历史沿革和对六经辨证的认识，以帮助读者正确理解此书的涵义；第二讲论述了《伤寒论》条文排列的有机联系，剖析了《伤寒论》的辨证思想和方法；第三讲是讲六经为病提纲证的现实意义；第四讲介绍了《伤寒论》的气化学说，是以传统的医理去分析六经、六气阴阳变化的规律。以上四讲为本书的总论，它起到指导各论进行辨证的作用。

从第五讲至第十三讲为各论，采用了以方带证的归类方法，把太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病的主要方证进行了归纳，并附有后世的方证和医案，以加强临床使用。

最后一讲是本人使用经方的心得体会，也是对上述各论的简明扼要的总结。希冀在理论上有所启迪，对临床有所借鉴，而为本书写作之目的。限于个人的水平，书中一定存在着许多不足之处，敬希读者不吝批评指正。

刘渡舟
1982年5月于北京

目录

第一讲 《伤寒论》 导言

- 一、《伤寒论》的历史变革
- 二、《伤寒论》是一部什么书
- 三、六经的概念
- 四、六经辨证方法
- 五、六经为病传变
- 六、“六经”析疑
- 七、论八纲辨证与六经辨证的关系
- 八、《伤寒论》的治疗法则
- 九、《伤寒论》的方剂
- 十、学习《伤寒论》的方法

第二讲 试论《伤寒论》条文组织排列的意义

- 一、《太阳病上篇》**30**条
- 二、《太阳病中篇》**97**条
- 三、《太阳病下篇》**51**条
- 四、《阳明病篇》**84**条
- 五、《少阳病篇》**10**条
- 六、《太阴病篇》**8**条
- 七、《少阴病篇》**45**条
- 八、《厥阴病篇》**58**条
- 九、《霍乱病篇》**10**条
- 十、《阴阳易瘥后劳复病篇》**7**条
- 十一、小结

第三讲 试论六经为病提纲证的意义

- 一、太阳病的提纲证
- 二、阳明病的提纲证
- 三、少阳病的提纲证
- 四、太阴病的提纲证
- 五、少阴病的提纲证
- 六、厥阴病的提纲证

第四讲 《伤寒论》的气化学说

- [一、太阳经病](#)
- [二、阳明经病](#)
- [三、少阳经病](#)
- [四、太阴经病](#)
- [五、少阴经病](#)
- [六、厥阴经病](#)
- [七、小结](#)

[第五讲 试论桂枝汤的加减证治](#)

- [一、桂枝汤的适应证](#)
- [二、桂枝汤的临床应用](#)
- [三、桂枝汤的加减应用](#)

[第六讲 试论麻黄汤的加减证治](#)

- [一、麻黄汤的适应证](#)
- [二、麻黄汤的临床应用](#)
- [三、麻黄汤的加减应用](#)

[第七讲 试论苓桂剂的加减证治](#)

- [一、水气的概念](#)
- [二、水气上冲的证机](#)
- [三、水气上冲的证治](#)

[第八讲 试论白虎汤类的加减证治](#)

- [一、白虎汤](#)
- [二、白虎加人参汤](#)
- [三、白虎加桂枝汤](#)
- [四、竹叶石膏汤](#)
- [五、白虎加苍术汤*](#)
- [六、玉女煎*](#)
- [七、化斑汤*](#)

[第九讲 试论承气汤类的加减证治](#)

- [一、大承气汤](#)
- [二、小承气汤](#)
- [三、调胃承气汤](#)

- [四、麻子仁丸](#)
- [五、桃核承气汤](#)
- [六、厚朴七物汤](#)
- [七、厚朴三物汤](#)
- [八、厚朴大黄汤](#)
- [九、大黄硝石汤](#)
- [十、大黄牡丹皮汤](#)
- [十一、三一承气汤*](#)
- [十二、黄龙汤*](#)
- [十三、增液承气汤*](#)

[第十讲 试论柴胡汤类的加减证治](#)

- [一、小柴胡汤证治](#)
- [二、小柴胡汤的加减证治](#)

[第十一讲 试论理中汤类的加减证治](#)

- [一、理中汤](#)
- [二、桂枝人参汤](#)
- [三、甘草干姜汤](#)

[第十二讲 试论四逆汤类的加减证治](#)

- [一、四逆汤](#)
- [二、四逆加人参汤](#)
- [三、通脉四逆汤](#)
- [四、通脉四逆加猪胆汁汤](#)
- [五、白通汤](#)
- [六、白通加猪胆汁汤](#)
- [七、干姜附子汤](#)
- [八、茯苓四逆汤](#)
- [九、附子汤](#)

[第十三讲 对寒热错杂诸方综述](#)

- [一、半夏泻心汤](#)
- [二、附子泻心汤](#)
- [三、黄连汤](#)

[四、乌梅丸](#)

[五、麻黄升麻汤](#)

[六、干姜黄芩黄连人参汤](#)

[第十四讲 使用经方的关键在于抓住主证](#)

[一、什么是主证，为什么要先抓主证](#)

[二、抓主证，也要注意兼证](#)

[三、变证的形成及其临床意义](#)

[四、夹杂证形成的特点](#)

[五、抓主证，使用经方的治例](#)

[六、小结](#)

[返回总目录](#)

第一讲 《伤寒论》导言

一、《伤寒论》的历史变革

《伤寒论》原名叫《伤寒杂病论》，也有人叫《伤寒卒病论》，考“卒”字乃是“杂”字的误写。

这部书是公元196—204年后汉人张机（字仲景）所写的作品。张仲景，南阳郡涅阳人，约生于公元150—219年，他的事迹汉书无传。据唐《名医录》载：“南阳人，名机，仲景乃其字也。举孝廉，官至长沙太守，始受术于同郡张伯祖，时人言，识用精微过其师。所著论，其言精而奥，其法简而详，非浅闻寡见所能及。”

东汉末年，连年战争，百姓流离失所，导致了疾疫流行，死的人很多。张仲景家族是拥有两百多人口的南阳大族，在疫情的危害下，还不到十年时间就死亡了三分之二的人口，其中死于伤寒的则占十分之七。张仲景在序文中曾哀叹地说：“感往昔之沦丧，伤横夭之莫救”，从而激发了他著书活人的志愿。为了著书济世，他勤求古训，博采众方，广泛地吸收了汉以前的医学成就，并结合自己的体会，在前人的基础上又有所创新，经过辛勤的劳动和反复的印证，终于写出了《伤寒杂病论》十六卷。

这部作品问世不久，就遭到了兵火的摧残，致使原书十六卷残缺不全。

公元256—316年，西晋太医令王叔和搜集了一些残存之书，进行整理并撰次成篇，但只整理了十卷，对十六卷的原貌已不复见。所以晋以后的《隋书·经籍志》和《唐书·艺文志》只载《伤寒论》十卷，而不再称十六卷。

到了公元1065年，宋朝的治平年间，政府指令高保衡、林亿等人校正医书，把开宝年间节度使高继冲进上的《伤寒论》十卷，总二十二篇，加以校正，同时梓板而颁行于世。

在这个期间，翰林学士王洙在馆阁日，从蠹简中检得的《金匱玉函

要略方论》三卷，也加以校正而刊行于世。

二、《伤寒论》是一部什么书

《伤寒杂病论》本来是伤寒与杂病有机联系，相提并论的一部书。自宋治平梓板简称《伤寒论》，而林亿等人又有十卷论伤寒，六卷论杂病的说法，使人误解为《伤寒论》是专论伤寒，而《金匱玉函要略方》则专论杂病，这一看法一直流传至今。

为了正确理解本书，先介绍一下什么是伤寒，什么是杂病，以及伤寒与杂病的内在联系，方能对本书作出正确的评价。

先说伤寒：伤寒有广义和狭义之分。《素问·热论》说：“今夫热病者，皆伤寒之类也。”这句话是指广义伤寒而言。及于狭义伤寒，则只限风寒，而不包括风寒以外的其他邪气。

考《伤寒论》的内容则是主论风寒，兼论杂病，它虽亦提及温病等证，乃是与风寒进行鉴别，作为伤寒类证而出现的，所以，不像风寒那样论述全面，也没有系统的治法。因此，还不能说《伤寒论》就是讲的广义伤寒。

再说杂病：汉时对疾病的分科，尚无今日内外科之称，当时对外感发热的急性热病，皆叫做伤寒；对伤寒以外的疾病，包括了许多慢性病，都称之为杂病。

伤寒与杂病，本来是两种不同的发病形式，但张仲景把它们共糅一书之中，而相提并论的理由是和以下几个问题有关的：

1.因伤寒单纯发病者少，而与杂病相兼者则多，故伤寒与杂病合论则全面。

2.人分男女，体有强弱，感邪虽一，发病则异，而且内因是变化的根据，故辨证不明杂病，不明脏腑的寒热虚实，则亦不能明伤寒。所以，只论伤寒，不论杂病，则不能曲尽辨证之长。

3.有的病人先患他病，后感伤寒，内伤外感，病情杂沓，难求一致，无法用伤寒一种发病形式而统摄诸病。

基于上述的问题，柯韵伯对此深有体会地说：“伤寒之中最多杂病，虚实互显，故将伤寒、杂病合而参之，此扼要法也。”

综上所述，可以看出，《伤寒论》是通过伤寒与杂病的具体事实，

以反映它的辨证方法。也可以这样说，伤寒与杂病必须共论，方能显示六经辨证以统摄诸病的意义。故柯韵伯又说：“盖伤寒之外皆杂病，病不能脱六经，故立六经而分司之。”反映了六经辨证以统摄伤寒、杂病这一事实。

同时应该指出的是，《伤寒论》这部书言简意赅，极尽含蓄吐纳之能事，故在辨证说理中有其潜移默化的感染力，起到了文以载道的效果。

另外，还应看到作者在六经辨证中，只讲某经之为病，不讲某经之伤寒，把百病兼括于六经而不能离其范围，所以它只在六经上求根本，而不在伤寒上求枝叶，因而突出了六经辨证的特点。

方中行也认为：《伤寒论》是论病之书，非为伤寒一病而设，这些提法，确实抓住了《伤寒论》的主要精神。

根据上述理由，说明了伤寒与杂病互相共论以阐明辨证论治之理，本来不存在伤寒在前、杂病在后，或十卷论伤寒、六卷论杂病的说法。学习《伤寒论》目的在于辨证论治，绝不可降格以求而满足于辨伤寒之一病。

三、六经的概念

六经的实质：《伤寒论》以六经辨证为核心，究竟六经的实质是否存在，在伤寒学中也议论纷纷，莫衷一是。有的学者把六经为病，归纳成六类证候，用以赅括阴阳表里、寒热虚实等证情。如丹波元坚在《伤寒论述义》中曾说“伤寒论一部，全是性命之书.....所谓病者何也？三阴三阳是也。热为阳，寒为阴，而表里虚实，互有不同，则六者之分，于是立焉。”

可以看出，他是把六经建立在阳热阴寒的证候之上，而不是把六经证候建立在脏腑经络之上。为此，他又指出：“至于经络脏腑之言，经中间或及之，然本自别义，非全经之旨。惟以寒热定阴阳，则触处朗然，无不贯通也。”

由此可见，丹波元坚的学术观点，是反对从《素问·热论》的六经理论来探讨六经实质的，这种思潮在国内也大有人在，实有加以澄清之必要。

我认为：《伤寒论》的六经，是继承了《热论》的六经学说，而有

其脏腑经络的物质基础，所以，六经是物，而并不是六个符号。如果离开中医的传统经络学说而去解释六经则是皮之不存，毛将焉附。因为从《内经》到《伤寒论》的脏腑经络学说，本来是一脉相承的，如本论的太阳病提纲，先揭出头项强痛一证，它和《热论》说的“其脉连风府”的精神而完全符合。

论中除汤液治病以外，还有许多按经取穴的针刺之法，如果像丹波元坚那种没有经络的说法，岂不成为无源之水和无本之木。所以，我们不能离开脏腑经络而去讲辨证论治。

但是，《伤寒论》却又和《热论》不一样，它在六经辨证上比《热论》有了发展。它不但能辨热证和实证，而且也辨阴证、寒证和虚证。可以这样说，《热论》的六经只辨伤寒，而《伤寒论》的六经，既辨伤寒，又辨杂病，从而建立了辨证论治的理论体系。

六经是脏腑经络，而辨证则是对脏腑经络生理、病理认识的客观分析。由此可见，祖国医学的辨证思想是建立在经络脏腑的物质上，而决不是空洞和抽象的说教。

四、六经辨证方法

《伤寒论》在古典医籍中，以辨证论治的方法见称。然而，辨证论治的方法，也并不是从《伤寒论》开始。观序中的“并平脉辨证为伤寒杂病论十六卷”的提法，可见古代已有辨证的专著。日人山田正珍说：“《平脉辨证》诸书，今皆不传”。其实早在战国时期《黄帝内经》中的阴阳学说引进医学领域以后，就大大开阔了医学家辨认疾病的眼界，并以此奠定了中医的辨证思想基础。

为此，张仲景的三阳三阴六经辨证，以及后世的八纲辨证，无不以阴阳为辨证之纲，这完全符合《素问·阴阳应象大论》说的“善诊者，察色按脉，先别阴阳”的精神实质。因为诊病时，能运用阴阳的辨证思想，就能“知丑知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有纪，诊道乃具”；否则，就“知左不知右，知右不知左，知上不知下，知先不知后，故治不久”。所以，阴阳学说渗透到祖国医学学术领域的各个方面，它不仅用以说明人体的生理功能、病理变化，而且也用以指导临床的诊断和治疗。

张仲景继承了阴阳学说，并结合临床实践，使之又有了新的发展。

《伤寒论》的六经辨证，就是以阴阳为纲，即用三阳、三阴的阴阳两纲总统六经。所以，六经辨证应首先解决病发于阴，还是病发于阳。阴阳病性既明，则是治病求本之道，也是以纲带目之法。然后在阴阳两纲指导下，进一步探求病位之所在，病情之所属，病势之进退，而判明表、里、寒、热、虚、实的情况，自可迎刃而解。八纲辨证可以说是辨证中的先决条件，但是，如果只辨到八纲程度为止，那还是不够的，因为它还没有具体地把人体的脏腑经络病理变化结合起来，就好像找人只找到了街道，还没有找到住户一样，仍然不能确切而深刻地阐明各种复杂的病理变化，并进一步指导临床治疗。而六经辨证就恰好地解决了这个问题，它把八纲的内容落实到脏腑经络之上，使八纲辨证与脏腑辨证有机地结合起来，从而也就弥补了八纲辨证之不足。

由于六经辨证贯穿着八纲而联系于脏腑经络，尤其是以脏腑经络生理、病理变化作为物质基础，使辨证言之有物，而不是空中楼阁。前人在研究《伤寒论》六经时曾指出：“经者，径也”，据经则知邪气的来去之路；“经者，界也”，据经则知病有范围，彼此不相混淆。有了范围，有了界限，就能使我们在辨证时一目了然。如见头项强痛，可知是太阳经受邪；见缘缘面赤、额痛、鼻干，可知是阳明经受邪；见耳聋、胸胁苦满，可知是少阳经受邪；见腹满时痛，可知是太阴经受邪；见咽痛，可知是少阴经受邪；见巅顶痛、干呕吐涎沫，可知是厥阴经受邪。如果离开经络学说，对上述各个证候的发生与机理，就无法进行解释。又由于经络系统的联络交会，使人体的五脏六腑、表里上下、四肢九窍、皮肉筋脉等各个组织器官联结成为一个有机的统一整体，因此六经辨证也特别注意脏腑经络病变的表里相互影响。如发热、恶寒而脉浮者，是属太阳经表受邪；若脉不浮而反见沉象，则知太阳表邪而又内累少阴。太阳与少阴为表里，当少阴阳气不足而外感风寒时，可以两经同时受邪，形成太阳与少阴的“两感”证。脾与胃互为表里，在发生病变时亦相互影响，故有“实则阳明，虚则太阴”的说法。这种病机的相互影响，表现在具有表里关系的经络脏腑之间联系，所以，辨证绝不能离开经络。宋人朱肱认为：“治伤寒先须识经络，不识经络，触途冥行，不知邪气之所在”，他说明了认识经络的重要意义。

五、六经为病传变

六经为病不外正邪斗争的进退变化，然正气有强弱之分，邪气有微甚之别，因而就有传经与不传经的问题。

一般地讲，凡邪气由表入里，由阳入阴，属于邪盛而病进；若正气抗邪有力，能拒邪外出，由里出表，或由阴转阳，属于邪衰而病退。但是决定是否传经，在于正气的盛衰和治疗、护理是否得当，其中尤以正气的抗邪能力为先决条件。

辨病邪传变，对治疗和预防都有现实意义。其辨认方法，正如论中所说：“伤寒一日，太阳受之，脉若静者为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也”。接着仲景又说：“伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。”他说明了分析传经与不传经，要从其脉证变化入手，而不是按六经顺序自然发展入手，更不是日传一经，以日而计传经为目的。

邪气传经的形式，归纳起来约有三种情况：

1.一般传经

如太阳之邪或传阳明，或传少阳。

2.表里传经

如太阳之邪，内传少阴；或少阳之邪，内传厥阴等。

3.越经传

太阳之邪，不传阳明、少阳而传于太阴等。一般传经以外，若其脏气不足而又有“直中”之说。直中，指病邪不经太阳、阳明、少阳而开始发病即见少阴证候，就叫做“直中”。这主要由于阳气虚衰，抗邪无力，邪气长驱直入而直接中脏，所以，它比以上的传经之病更为严重。

传经以外，还有“合病”与“并病”。合病与并病的情况，据丹波元坚说：“合病并病者，表里俱病是也。方其感邪，表里同时受病者，谓之合病。表先受病，后传于里，而表犹在者，谓之并病。合病则剧，并病则易，此合、并之略也”。以上丹波元坚的话，突出说明了“合病”与“并病”的各自特点。由上述可见，凡两经、三经同时发病，不分先后次第的叫“合病”，合病多为原发。

合病共有四种：分为太阳阳明合病，太阳少阳合病，少阳阳明合病，三阳合病。

若一经之病未愈，继而另经之病又起，而有先后次第之分叫“并病”，并病多为续发。

并病有两种：分为太阳阳明并病，太阳少阳并病。

三阴经病虽无合病、并病之称，然确有其实的内容，这里就不多谈了。

六、“六经”析疑

目前，在研究《伤寒论》的六经实质问题上，出现了百家争鸣的局面，这是围绕对六经的不同认识而展开的。概括起来可归纳为两种，一种见解认为《伤寒论》的六经，是继承了《素问·热论》的六经分证方法，以经络学说为根据，从而反对六经不是经络的观点；另一种见解则恰恰相反，他们认为《伤寒论》的六经虽有“阶段”、“地面”、“症候群”、“六病”、“八纲”等等说法，千姿百态而蔚成大观，但都与《热论》之经络六经风马牛不相及，从而否定了经络六经之说。

以上两种观点展开的讨论，必将促进学术上的繁荣和发展，并能澄清长期以来六经中一些纠葛不清的问题，故为广大医家所瞩目。为了交换意见，本着抛砖引玉的态度，试对六经问题进行辨析，藉以就正于各位同道。

我认为对中医古典医籍的研究，一定要采取历史唯物主义和辩证唯物主义的观点。有了这一前提，才能克服主观片面与割断历史的流弊。从这个原则出发，我体会《热论》之六经和《伤寒论》之六经，虽有一前一后之分，但从年代来看，距离并非甚远，而后者受前者影响之深也自不在言外。如果像有些同志所认为的那样，《伤寒论》的六经，已是“天马行空”完全脱离了《热论》之窠臼，而以全新的姿态出现的话，则无论从历史年代还是从学术渊源来分析，都是值得商榷的。因为《热论》的六经分证方法，在当时仍居于权威地位，而经络学说尤为当时医家所推崇，那么，张仲景为何摒弃经络而不用，这是令人费解的。日人丹波元胤曾就此事发表了他的意见，很值得参考。他说：“阴阳五行，汉儒好谈之，五脏六腑、经络流注，《史记·扁仓传》问及于此，《汉书》亦多载其书目，仲景生于汉末，何独摒去？”这种尊重客观事实，从历史唯物主义出发的观点，不能不令人为之首肯。当然我们看问题，也不能只讲六经的继承而不讲六经的发展。但是，继承和发展乃是辩证的关系。也就是说，在继承的前提下，然后方可谈发展。事实上，张仲景也承认他撰用了《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》等书以为借鉴，从而写成了《伤寒杂病论》合十六卷。为此，明朝

鄞县人吕复说：“《伤寒论》十卷，乃后汉张机，仲景用《素问·热论》之说，广伊尹汤液而为之。”他认为《伤寒论》的六经是本于《热论》的，而其中的汤液治病，则源于伊尹的《汤液经》。吕复的话，无疑是正确的，但应该为之补充，使之全面。即仲景虽然继承了《热论》的六经，却比《热论》有新的发展。具体而言，他不但用六经辨热证和实证，而且同时也扩展到辨阴证、虚证和寒证。所以，张仲景发展了《热论》的六经，在《热论》的基础上又有所突破，而为中医学的辨证论治开辟了广阔的途径。

由此可见，如果不承认《伤寒论》的六经有继承性，则难免犯割裂历史的错误；反过来说，只看到继承，而看不到发展的一面，也难免有“厚古薄今”与固步自封之诮。所以，我们研究《伤寒论》，应当是既看到它的继承，又看到它的发展，方不至于片面。

然而，有的同志对继承与发展的关系，在认识上存在片面性，对经络学说基本理论的研究也欠严谨，因而在学术上表现了轻率的态度，想把经络学说从六经辨证中一脚踢出门外，而创立出“六经与经络无关”之说。殊不知，如果《伤寒论》没有经络的存在，没有脏腑的核心，而欲完成辨证论治的任务，可以说是“未之有也”。这是因为，经络、脏腑、气化的系统体系，是病因与病理变化的客观基础，是辨证治疗的内在依据。如果废弃了这一系统，而代之以其他名目，那么，对致病之因、受病之所，以及证候的复杂表现，就会感到头绪万千，毫无层次可言。由于失去了理论上的指导，辨证论治也就成了无源之水与无本之木，也就必然背离了中医之道。

《灵枢·经别》说：“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起，学之所始，工之所止也。”它说明了凡病的所成与所起，都与经络有联系。经言皇皇，昭如日月，那么，六经辨证岂能与经脉无关？由此推论，无论任何疾病都不应离开经络而存在。所以，如果否定经络的存在，不独《伤寒论》一书为然，而整个经络学说也同样将被人所废弃。经络学说如果从中医理论上砍掉的话，则中医还有什么特色可言？

《伤寒论》这部书，贯彻了中医的“整体观”和“辨证观”，所以才能成为不朽之作。然而，整体观和辨证观都是在六经经络学说指导下而实现的，兹分述如下，以见其义。

1.整体观

由于人体经络内连脏腑，外络肢体与孔窍，网维周身，而使表里内

外、上下左右，互相沟通，息息相关，成为一个有机整体，故扯一毛而动全身。如足太阳膀胱虽居下焦而有主一身之表的功用，足少阳胆虽居右胁内，而有主半表半里的功用等等。同时，经络脏腑在统一的整体下，又有它们各自的部位与界限，因此，在病理上也有各不相同的反映。根据每个经的特殊性，在病理变化上去辨阴阳、划表里、分脏腑、定寒热，以知某经、某腑、某脏的为病，以及由表入里，或由里出表与由阳转阴，或由阴出阳的等等变化。因为有了整体观的认识，所以辨证时会有机联系，不局限一处；因为有经络规律可循，则对病变的或表或里，才可能有统一的认识，这样辨证识病就井然有序。

2.辨证观

在整体观的前提下，我们掌握了经络脏腑的阴阳表里关系（如太阳与少阴为表里，阳明与太阴为表里，少阳与厥阴为表里等），由于阳经与阴经互相联系而相通，因而无论病发于阴，或病发于阳，便不是一成不变的，而都有一个阴阳互根，一分为二的问题。所以，古人说：“实则太阳，虚则少阴。”可见，太阳病中内伏少阴之机，凡是具备了“虚”的条件时，太阳就可变为少阴，少阴“实”时，又可外出太阳。大家知道，六经阴阳也包括了八纲辨证的内容，但由于六经阴阳具有可变性，所以阴阳、表里、虚实、寒热有可能向各自对立的相反方向转化。应当看到，这样的变化决定于经络脏腑客观条件的改变。所以，我们强调经络学说这一中医特色，是从尊重经络学说带有唯物论与辩证法的核心出发的。因此，割断经络这个沟通阴阳脏腑的纽带，对中医的辨证则带来了极大的困难。

凡研究《伤寒论》的学者，都知道太阳主表，为一身之外藩，总六经而统营卫，肥腠理而司开阖，卫外而为固。那么，太阳之气又是如何主表的呢？《素问·热论》说：“巨阳者，诸阳之属也。其脉连于风府，故为诸阳主气也。”从这段经文可以看出太阳经脉上连于风府，而为诸阳之属（张隐庵注：属，会也），故为诸阳的主气，从而获“巨阳”之称，乃有主持一身之表的功用。假如说太阳之脉不上连风府，而不与督脉会合，则也就不能为诸阳主气，所以也就不能主表。从《热论》来看，文义是大致如此的。柯韵伯在《六经正义》中，有“不为经络所拘”一语。他认为经络循行部位比较局限，于是乃有以“六经地面”而代替经络之论，实际上柯氏是忽视了“其脉连于风府”所起的整体作用，才致有此失的。

《伤寒例》说：“尺寸俱浮者，太阳受病也……以其脉连风府，故

头项痛，腰脊强。”它说的“太阳受病”是指经脉而言，其义与《素问·热论》“其脉连于风府”遥相呼应，是前后一致的。仲景在《太阳病篇》的第一条又说：“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。”这个“头项强痛”也是反映太阳经脉上连风府的一种病变，而与《热论》、《伤寒例》如出一辙，故可见六经为病内有经络之实，则不辨而自明。所以，我们说太阳病有经证与腑证之分，是以经言为宗旨的，并非出自臆断。然而有的同志不从以上的方法去研究问题，而用望文生义的眼光，认为仲景在“太阳”之下，没有写出“经”字，就认定张仲景不讲“经”而讲“病”，因此提出一种“六经无经络”的论点。他们不知道，太阳是受邪之体，风寒乃所受之因，故在第四条的“伤寒一日，太阳受之”一句话里，乃是讲的能病的是伤寒，与所病的则是太阳经。如认为太阳无经络，则太阳就名存实亡，那么，又以何物接受其邪呢？由此可知，太阳经是客观存在的，是在受病之先，而太阳病是在太阳经受邪之后，故称“六经之为病”而不称“六病之为病”，其理由就在于此。正因为先病于经，而成太阳表证，如果表证不解，则邪可随经入腑，而构成太阳腑证。太阳的经证，一般则使荣卫不和，而有荣弱卫强的中风，与荣郁卫闭的伤寒；太阳的腑证，则可使膀胱的气血不利，故有气化不行的蓄水证和热与血结的蓄血证。这种以太阳经、腑为系统的表里内外与荣卫气血的病理变化，看来是变化多端，难于辨认，但掌握了太阳经的发病规律，就能执简驭繁，做到心中有数，井然不紊，从而也就发挥了六经辨证的临床作用。至于六病辨证，虽然亦能从客观的病证出发，而分其阴阳、表里、寒热、虚实，但总不免知其然而不知其所以然，缺乏对疾病的系统认识，又不讲生理、病理的原委，想仲景之学谅非如此简陋。

太阳经脉不但下连膀胱，而又下连于少阴之肾，形成了膀胱与肾相表里的特殊关系。以是之故，在太阳病中，或因年迈，或因下虚，或因误治，导致少阴阳气先拔，不能支援太阳之气抗邪于表，反使太阳在经之邪从太阳之表，而飞渡少阴之里，故表现脉来微细，神疲欲寐，而发热、脉反沉的证象，称之为“太少两感”之证。亦有少阴病，发生八九日之久，如少阴阳气得复，寒邪化热，正气拒邪，外出所合之膀胱，则可出现一身手足尽热之证。因其热在膀胱，必迫血妄行，则有便血之证发生，然阴证转阳，则如理而为顺也。

上述的以经脉为联系的太阳与少阴发病关系，表现为由阳入阴，或由阴出阳的阴阳转化之机，以体现阴中有阳，阳中有阴的对立统一的辩证关系。可见经络学说是构成中医的辨证理论的基础，对临床既非常实用，而其义理又较为深奥。所以，弃之则甚易，而学之则又甚难。张仲景笃信经络之学，在他的自序中才说：“经络府俞，阴阳会通，玄冥幽

微，变化难极，自非才高识妙，岂能探其理致哉？”而宋人朱肱也深深体会到经络在《伤寒论》中的重要性，而又有易被人所忽略之弊，所以才说：“张长沙《伤寒论》，其言奥雅，非精于经络不能晓会。”

朱肱是重视《伤寒论》的经络学说的，但他并不是以经络而论六经的创始人，察“六经”之名，始见于皇甫谧的《针灸甲乙经》。然而一些排斥六经的经络者，又往往认为朱肱是“从经络为六经”的始作俑者，以讹传讹，故愿为之更正。

或有人问：《伤寒论》经王叔和之撰次，已失其真，而《伤寒例》乃王氏托名仲景旧论，而塞进了他自己的经络之说。如柯韵伯所论：“叔和不知仲景之六经是经略之经，而非经络之经。”而方有执与喻嘉言亦驳其舛谬，并削去《伤寒例》而将原文亲为考定，已为伤寒家所称颂。而今反以《伤寒例》经络之说，亦为不可移易之理，岂不谬哉？余曰：君只知其一，而反被方、喻之说所左右。王叔和以功遭忌，蒙此不白之冤而直至今日，实亦不平之甚矣。平心静气而论，“张经王传”，赖以行世，况叔和距仲景年代甚近，故考核遗文，采摭群言，甚得仲景之旨。林亿曾说：“自仲景于今，八百余年，唯王叔和能学之。”成无己亦说：“仲景之书，逮今千年，而显用于世者，王叔和之力也。”他们的话是对的。因为仲景之书散失于三国兵燹之中，若无叔和为之整理、撰次，则劫后余灰，安得流传于今日？至于《伤寒例》本为仲景之旧论，而实出于《内经》之旨，验之临床，又多能中病，故其实用价值甚高。今方有执创之于先，而喻嘉言又步之于后，他们虽为伤寒大家，而未可妄议，惟其臆断孰为仲景文，孰为叔和文，活龙活现，俨然以仲景化身自居，肆意颠倒叔和撰次之文，故汪琥为之不平，而有“三家（方、喻、程）之书，皆倒乱仲景六经篇文，彼虽各有其理，要之六经原次，或当日叔和未尽改易，其间仲景妙文，焉知不反由此新编而尽失耶？”他的话简当有力，确实击中了问题的要害。由此可见，方、喻等人名曰维护仲景之旧，实则反乱原书之真，明为贬王，暗则褒己，由明、清迄今使叔和之冤枉如此之久，吾辈忝列医林，岂能坐视而闭口不言，使其说流散无穷耶？况且，王叔和与皇甫谧皆为同时之人，而又知之甚详，《甲乙经》序说：“伊尹以元圣之才，撰用《神农本草》以为汤液，汉张仲景论广汤液为十数卷，用之多验，近世太医令王叔和撰次仲景遗论甚精，皆可施用”。由此可见，若王叔和果如方、喻等人之所谤，则皇甫氏能用“撰次甚精”四字而称许之？以此而言，在中医学学术界里，还有一些混淆视听的问题，而且又往往以讹传讹，流布甚广。对此，本着争鸣的愿望，谨抒管见。

七、论八纲辨证与六经辨证的关系

八纲辨证最早见于宋人许知可的《伤寒百证歌》。其中记述了阴阳表里寒热虚实的证候情况，并且，在阴阳表里寒热虚实八者之中，他认为尤应以阴阳为纲。他认为阴阳不辨，便无法进一步分析表里寒热虚实。在许知可的学术影响下，明清两代，一些杰出的医家，如张景岳、程钟龄、江笔花等人，他们也像许氏一样，从《伤寒论》抽出阴阳两纲，以统领表里、寒热、虚实的辨证。我们从江笔花写的《表里虚实寒热辨》一文，可以看出当时的提法，只是阴阳称纲，然表里虚实寒热犹未提到纲的高度。

江氏说：“凡人之病，不外乎阴阳。而阴阳之分，总不离乎表里、虚实、寒热六字。夫里为阴，表为阳，虚为阴，实为阳，寒为阴，热为阳，良医之救人，不过辨此阴阳而已，庸医之杀人，不过错认此阴阳而已。”他的说法和张景岳的“两纲”、“六变”的主张基本相似。可以说，八纲辨证的发展，是在阴阳两纲的前提下逐渐被人们所公认的，这也是历史的事实。然而，必须指出的是，八纲辨证的思想，源于《伤寒论》的阴阳六经辨证。而在《伤寒论》中，六经与八纲则又是紧密相连，密切结合，缺一不可的。这是因为，六经是脏腑经络的概括，它是客观存在的。而辨证必须建立在客观上，所以诸病不能越出六经的范围。同时六经的证候表现，也不能离开八纲分证的规律，因此，二者必须互相结合才能完善地用于临床辨证。现将八纲辨证与六经辨证相结合的具体方法介绍如下：

（一）阴阳

《内经》云：“治病必求于本”，“生之本，本于阴阳。”故阴阳两纲，既为六经之纲，又是八纲之纲，用以统摄诸证及其发展变化。阴阳既是对立的，又是统一的，在每个事物中，都有两方面的问题，而是可分与可变的。现以三阳病为例说明。

1. 太阳病

太阳与少阴互为表里，可分阴阳。若脉浮发热而恶寒的，则为病发于太阳，叫做阳证。若脉沉，无热而恶寒的，为病发于少阴，则叫阴证。

2.阳明病

阳明与太阴为表里，故有阴阳之分。若身热汗出，不恶寒，反恶热的，则为病发于阳明，叫做阳证；若阳明中寒，内转太阴，而不能食，小便不利，手足出冷汗，大便初硬后溏，为病发于太阴，则叫做阴证。

3.少阳病

少阳与厥阴为表里，故有阴阳之变。若其人往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕，为病发于少阳，则叫做阳证。若见耳聋、囊缩而厥，水浆不下，舌苔黑滑，为病发于厥阴，则叫做阴证。

由上述可见，阳经之病多发于六腑，因腑为阳，气血充盈，抗邪有力，故以各种热象为特点；阴经之病，多发于五脏，因脏为阴，气血虚寒，抗邪无力，故以各种寒象为特点。若对阴证、阳证推而言之：凡身轻，气喘，口鼻气热，目睛了了，不能睡眠；或热极朦胧，视物不清；或目赤多眵；或身热面赤唇红；或烦渴而小便红黄，则皆为阳证的反映。若身重，口鼻气冷，目不了了，但欲卧寐，面色不红，四肢厥冷，爪甲色青，吐利而小便色白，则皆为阴证的反映。

古人说：“阳极似阴，阴极似阳”，所以，辨阴证阳证时，须区别其真伪，不能被其表象所惑。《伤寒论》第11条说：“病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。”仲景认为“证之象有真伪，而欲与不欲之病情”，则为可信，故依之而辨真寒假热与真热假寒之证。临床之时，若师其义而长之，则庶几近之。

（二）表里

阴阳六经为病，皆有一个发病部位的问题。因此，只有辨清表里病位，汗、下之法方能用之不失。为此，现将六经表里辨证分述如下：

1.太阳病表里证

（1）太阳病经表证：

六经为病，只有太阳病能当表证的提纲，这是与太阳的生理特点分不开的。由于太阳经上连于风府，为诸阳主气，故它总六经而统营卫，为一身之外藩，所以，太阳主表。另外，六经各有经、腑之分，凡经受邪，则称之为表证，腑受邪则称之为里证。

《伤寒例》说：“尺寸俱浮者，太阳受病也，当一二日发。以其脉上连风府，故头项痛，腰脊强。”《伤寒论》也有“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒”等证候，皆说明了邪伤太阳经表，太阳经气不利而发病的特点。

（2）太阳病里证：

太阳之腑为膀胱，而居于下焦之里。若太阳在经之邪不解，邪气随经入腑，由表及里，则有蓄水和蓄血的病变。我们将它叫做太阳病的里（腑）证。

太阳蓄水证：以脉浮，微热，消渴引饮，小便不利为主证，甚或见饮水则吐的，则叫做“水逆”证。

太阳蓄血证：太阳病，脉微而沉，反映了表邪入里，而有少腹硬满，精神发狂；或少腹急结，精神如狂，然小便自利，故知为热与血结，而与水无关。

2.阳明病表里证

（1）阳明病经表证：

《伤寒例》说：“尺寸俱长者，阳明受病也，当二三日发。以其脉挟鼻、络于目，故身热，目疼，鼻干，不得卧。”成无己注：“阳明脉起于鼻交頄中，络于目。阳明之脉，正上颞颥，还出目系……目疼鼻干者，经中客邪也。”此证还有发热，恶寒，无汗，缘缘面赤，额头作疼，脉浮而长等证候。

（2）阳明病里证：

若胃肠受邪，则叫阳明病里证。《伤寒论》第218条的“伤寒四五日，脉沉而喘满。沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难……”即指阳明胃肠里证为病而言。里证不能发汗，发汗则伤津液，故而大便为难。

3.少阳病表里证

（1）少阳病经表证：

少阳为半表半里，位居两胁，然从经腑而论，亦具有表里之义。

《伤寒例》说：“尺寸俱弦者，少阳受病也，当三四日发。以其脉循胁络于耳，故胁痛而耳聋。”成无己注：“胸胁痛而耳聋者，经壅而不利也。”而《伤寒论》第264条亦记载了“少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦……”等的少阳经证。

（2）少阳病里证：

指的是少阳腑证。《伤寒论》第263条说：“少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。”为邪热入于胆腑，迫使胆汁上溢则口苦，故称为少阳病的里证。

4.太阴病表里证

（1）太阴病经表证：

《伤寒例》说：“尺寸俱沉细者，太阴受病也，当四五日发。以其脉布胃中，络于嗌，故腹满而嗌干。”《伤寒论》第274条的“太阴中风，四肢烦疼……”第276条的“太阴病，脉浮者，可发汗……”都反映了太阴脾家的经表为病的事实。

（2）太阴病里证：

《伤寒论》第279条说：“本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也”。以及第277条说的“自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也”。这些都是指的太阴脾脏之里证而言。

5.少阴病表里证

（1）少阴病经表证：

《伤寒例》说：“尺寸俱沉者，少阴受病也，当五六日发。以其脉贯肾络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴。”这是论述少阴经的热证；

《伤寒论》第301条说：“少阴病始得之，反发热，脉沉者，麻黄细辛附子汤主之”，则是论述了少阴阳虚，经表受寒之证。

（2）少阴病里证：

是指少阴心肾两脏之病。如《伤寒论》第323条的“少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤”。又285条说：“少阴病，脉细沉数，病为在里……”这两条说明了少阴病既有阳虚的里寒证，又有阴虚的里热证。

6.厥阴病表里证

（1）厥阴病经表证：

《伤寒例》说：“尺寸俱微缓者，厥阴受病也，当六七日发。以其脉循阴器，络于肝，故烦满而囊缩。”而《伤寒论》第351条又说：“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。”以上两条反映了厥阴病经热和经寒为病的特点。

（2）厥阴病里证：

《伤寒论》第352条说：“若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。”“内有久寒”，是指厥阴脏寒里证而言。

以上我们用表里两纲，以反映六经的经络、脏腑之为病，这才能体现出中医辨证学的系统和完整。如果只讲脏腑的里证，而不讲经络的表证，则失六经辨证的宗旨。所以八纲辨证必须与六经辨证结合起来，才不致失于片面。

（三）寒热

寒热两纲，为反映六经寒热病情而设，以疾病有寒热两种情况为客观存在，故作为临床治疗中辨证分型的依据。因此，它便把表里、阴阳为病的具体病情概括无遗。

1.太阳病寒热证

（1）太阳病寒证：

太阳主表，然表病有寒热之分，不可不察。如《伤寒论》的“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者，名为伤寒”。这条以恶寒、体痛、脉紧反映出表寒为病的特点，故可称为太

阳病的表寒证。

（2）太阳病热证：

有寒必有热，此乃相对而生之故。然太阳病表热证，不外以下两种形式：一是感受温热邪气，如《伤寒论》的“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病”。因温热之邪尚在太阳，未全入里，故叫太阳病表热证。一是由于风寒束表，日久不解，则寒郁化热，而脉由紧变缓，身由疼变重，身无汗而精神烦躁的，也可称为太阳病表热证；此外尚有“太阳病，发热恶寒，热多寒少……”也属于太阳病表热证的一种。

2.阳明病寒热证

（1）阳明病里寒证：

《伤寒论》说：“若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。”此条论阳明里寒作哕；又说：“食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之。”此条论阳明里寒作呕，并提出了治法。

（2）阳明病里热证：

阳明病的里热证，有在上、在中、在下的不同。热在上，郁于膈脘，则心中懊恼；舌上生苔；热在中则渴欲饮水，口干而燥；热在下，则脉浮发热，渴欲饮水，而小便不利。

3.少阳病寒热证

（1）少阳病寒证：

其证见胸胁满闷，小便不利，渴而不呕，但头汗出，腹中胀，大便溏，脉弦迟等。

（2）少阳病热证：

其证口苦，心烦，咽干，目眩为主。

4.太阴病寒热证

（1）太阴病寒证：

《伤寒论》说：“自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也……”“脏

有寒”，指脾有寒，故症见腹泻而不渴。

（2）太阴病热证：

《伤寒论》说：“伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴。太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄。”

太阴为湿土，故发病而有湿热与湿寒的不同，必须辨别清楚而不能相混。

5.少阴病寒热证

（1）少阴病寒证：

少阴病寒证，包括甚广，《伤寒论》说：“少阴病，欲吐不吐，心烦，但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也……小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。”“以下焦虚有寒”一语，道破了少阴病的寒证实质。

（2）少阴病热证：

《伤寒论》说：“少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧……”说明了少阴病热证烦躁的情况。

6.厥阴病寒热证

（1）厥阴病寒证：

《伤寒论》说：“若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。”说明了其人肝有久寒，表现为下焦积冷，少腹冷痛，或上逆作呕等证。

（2）厥阴病热证：

厥阴病的热证，或感受热邪为病；或阳气被郁，久而化热；或厥阴阳复太过，热气有余等所致，《伤寒论》说：“伤寒一二日至四五日厥者，必发热；前热者后必厥，厥深者热亦深，厥微者热亦微。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。”说明了厥阴内热而有致厥之机。

（四）虚实

虚实两纲，常以反映六经为病，正邪斗争的虚实情况，大概来讲，凡三阳经病，多以实证为主，三阴病中多以虚证为主。

1.太阳病虚实

（1）太阳病表虚证：

太阳病为表证，若表证同时又汗出的，则叫表虚证。如《伤寒论》说：“太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出。啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。”是说太阳病中风表虚的脉证。

（2）太阳病表实证：

太阳病表证，若无汗而喘的，则叫表实证。如《伤寒论》的“太阳病，头痛，发热，身疼，腰疼，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之”。是说的太阳伤寒表邪的实证。

2.阳明病虚实

（1）阳明病里虚证：

阳明主里，而有虚实之分。阳明病的里虚证，如《伤寒论》的“阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。”成无己注：“胃为津液之府，气虚津少，病则反无汗。胃候身之肌肉，其身如虫行皮中者，知胃气久虚也。”

按：太阳主表，故以有汗为虚，无汗为实。阳明主里，则以有汗为实，无汗为虚，以见表里虚实之异。

（2）阳明病里实证：

阳明病的里实证，以“不更衣”、“大便难”为主要临床表现。《伤寒论》的“阳明之为病，胃家实是也”，就是论述阳明为病的特点。里实的具体证候有：不大便，腹满疼痛，或绕脐疼痛；或腹满不减，减不足言；或反不能食，脉沉紧，或沉迟有力，舌苔黄燥等证。

3.少阳病虚实

（1）少阳病虚证：

少阳病的虚证，如《伤寒论》的“伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤；不差者，小柴胡汤主之”。少阳病，脉本弦，今浮取而涩，沉取而弦，与太阳病的“尺脉迟”意义相同，反映了少阳病夹虚而气血不足之象。先与小建中汤以扶正气之虚，后用小柴胡汤以和解少阳之邪。

（2）少阳病实证：

是指少阳病胸胁苦满，心下急，郁郁微烦，呕不止，大便秘结，口苦心烦，脉弦滑有力等证。

4.太阴病虚实

（1）太阴病虚证：

太阴病的虚证，往往和寒证相连，如《伤寒论》的“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结鞕”。这一条充分反映了脾气虚寒的吐利之证。然临床所见，厥阴病寒证的吐利，是以吐为主而下利为次；而太阴病的寒证吐利，则以下利为主而呕吐为次，也不可不知。

（2）太阴病实证：

《伤寒论》说：“本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也……”“大实痛者，桂枝加大黄汤主之。”就说明了脾实可下之证。然其脉必沉而有力，如脉弱者，则不可用。

5.少阴病虚实

（1）少阴病虚证：

少阴病的虚证，应当分析阴虚和阳虚，如《伤寒论》的“少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。”这一条是讲，因脉微阳虚，故禁用汗法。又说：“少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。”这条以脉细数阴虚，故禁用汗法，从中反映出，少阴病的虚证而有阴阳之分。

（2）少阴病实证：

俗云：肾无实证，肝无虚证，此乃粗略之言，固不足取。然少阴病的实证从何得之？多以“中脏溜腑”的方式形成。如《伤寒论》的“少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，可下之，宜大承气

汤”。此条说明，燥热内实，迫阴下夺，穷必及肾，成为少阴病急下的实证。

6.厥阴病虚实

（1）厥阴病虚证：

厥阴病的虚证，有阳气虚和血虚的不同。阳虚的如《伤寒论》的“大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。”这是说的厥阴阳虚寒证。血虚的如《伤寒论》的“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之”。是说的厥阴血虚受寒之证治。

（2）厥阴病实证：

厥阴病的实证，一般都是郁遏气机，而有痰壅、水停以致肝气疏泄不利，气机不畅，而发生厥逆之变。如《伤寒论》的“病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。”此条论述了痰邪凝结胸中，厥阴气机不利的手足厥冷之证。又说：“伤寒厥而心下悸，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥。不尔，水渍入胃，必作利也。”此条是论水停于胃，肝不疏泄，气机不畅，手足厥冷之证，因内有水邪，故称为实证。

（五）小结

通过以上八纲辨证与六经辨证结合来看，于每一经中，皆有阴阳表里寒热虚实八个方面的变化，用以反映六经为病的证候规律，所以说它有辨证的纲领意义。然而八纲辨证又是在六经为病基础之上的客观反映，因此，八纲与六经是一个统一的有机体，是不可分割的。如果人为地把它们分割开来，则就必然破坏八纲辨证的物质精神和六经辨证的客观存在。

同时，中医的辨证学说，体现了经络脏腑生理病理的变化规律，所以唯有用八纲辨证方法才能统摄经、腑表里的病位；阴阳脏腑的病性；以及阴阳寒热、正邪虚实，无不一以贯之，才能做到有纲有目与了如指掌之快。

八、《伤寒论》的治疗法则

《伤寒论》这部书是有理法方药程序的。理，是指六经辨证之理，前边已作介绍。法，是指治疗的方法和指导治疗的原则。辨证最终目的在于治疗，用什么方法去治疗，用什么观点去指导治疗，确是临床上一个重要课题。

《伤寒论》在治法上确立了两个前提：一个叫“阴阳自和”，一个叫“保胃气，存津液”。

阴阳自和的意义：是说治病求本，本于阴阳；阴阳不和则病，使其阴阳自和则愈。因此，在治疗时，要从阴阳的大前提入手方得休。

“保胃气，存津液”的精神，是说治病时要把人、病、药三方面的关系摆正，其中“人”是主要的。这是因为治病服药，无非为的是人，因此，治病时就不要伤了人，因而提出了“保胃气，存津液”的法则。若没有这个法则，很可能在治疗中先伤了正气，正气先伤，则抗邪无力，而导致了邪气的滋长和发展，则使治疗处于被动。

《伤寒论》的治病方法归纳起来，有麻、桂的汗法，瓜蒂的吐法，硝、黄的下法，姜、附的温法，苓、连的清法，参、草的补法，柴、芩的和法，麝、蛭为丸的消法等等。

中医的治疗八法，从《伤寒论》而体现，后世医家奉为圭臬。临床治疗离不开“八法”的范围，所以，必须在“法”的正确指导下而后进行处方用药。

九、《伤寒论》的方剂

方剂的记载在现存的古医籍中，最早见于《黄帝内经》，它仅载13方，远不能满足临床治疗的需要。到了汉代，由于药物的不断丰富与发展，特别是复方的广泛应用，使方剂学在配伍理论、临床实践方面，均有较大的进展。近几年出土的汉代医药木简，为我们提供了这方面可靠的文物根据。从1972年12月在甘肃武威出土的一批东汉早期的医药简牍来看，内有医方30多个，而且几乎全是复方，用药约100种，可见当时的方药已有相当水平。由此可见，《伤寒论》中所载的方药，并不是张仲景所独创，但张仲景对于继承并发扬汉代以前的医药学遗产，将理、

法、方、药一脉贯通，开创辨证论治的治疗原则，而做出了重大的贡献。

《伤寒论》的方剂，上溯岐黄，下逮百世，有方书之祖称号，其主要成就有下述几点：

1.体现了治疗八法，在临床的具体应用上，奠定了方以法立，法以方显的理论。

2.组方精简，配伍严密，经亿万人次实践而疗效显著。

3.方证结合紧密，确能解决“证”的要求，成为有证必有方的治疗体系。

4.组方不拘一格，随证处施，不偏于一家之见，可为后世效法。

十、学习《伤寒论》的方法

学习《伤寒论》，主要是学习它的辨证论治的思想和方法，要做到这一点，就必须对祖国医学的基本理论，特别是有关阴阳学说，脏腑经络的生理、病理变化要融会贯通，从其病理变化的客观反映进行分析、综合、归纳，划分所属的六经范围，以制定相应的治法。同时要反复阅读原文，领会书中精神，记住证候特点，以及方剂的宜忌、剂量大小和煎服方法与“方后注”的要求。同时还必须把条文之间的关系和意义加以弄清，以增强对原文的深入体会，为此，第二讲专门讨论了条文组织排列的意义。

学习六经辨证方法要结合临床来学，陈修园主张的看病与读书结合起来是很有道理的，因为这样学习《伤寒论》收获大，而且对《伤寒论》也能有所发展。

第二讲 试论《伤寒论》条文组织排列的意义

《伤寒论》的文章结构，是以条文形式组成，据赵开美复刻的宋本《伤寒论》，有398条之多。《伤寒论》既然用条文以表达辨证论治，因此，学习《伤寒论》的基本要求之一就是理解条文和条文之间相互联系的意义。

应该看到，《伤寒论》398条是一个有机的整体，在条文之间，无论或显或隐，或前或后，彼此之间都有联系。作者在写法上，充分发挥了虚实反正，含蓄吐纳，对比互明，言简义永的文法和布局，从而把辨证论治方法表达无遗。

为此，学习《伤寒论》先要领会条文的排列组合意义，要在每一内容中，看出作者的布局和写作目的，能学到条文以外的东西，要与作者的思想共鸣，才能体会出书中的精神实质。

基于上述要求，试将《伤寒论》398条的相互关系，按六经范围加以论述，以为学习《伤寒论》提供参考。

一、《太阳病上篇》30条

《太阳病上篇》的条文为30条。从第1条到11条的内容是一书的纲领，而有指导全书统领辨证的意义。

例如第7条的内容辨病发阴阳；第11条的内容辨病有真假寒热，被认为是六经阴阳寒热的辨证纲要，贯串于全书之中，占有指导的地位。

第1条的内容，是太阳病的总纲，反映了表证的共同证候，以下凡言太阳病的皆以此条为准。第2、3条的内容，是在太阳病总纲之下，又分出中风与伤寒两类表证，两条并列不分，意在对比发明，用以加强辨证论治的分析。

第6条内容论温病，看来似乎同中风、伤寒有鼎足而三的意思，但它与第3条不并列，显而易见，作者是作为风寒的类证写出的。

第4、5两条，应联系一起体会，则知作者让人从脉证方面的变化，辨传经与不传经的方法。

第8条内容，论太阳病七日自愈，为邪行经尽；若此时邪气不衰，则有传经之变。作者示人针刺足阳明经，使其不传以杜其邪。说明在太阳病中有“传经”与“行经”的不同，同时也提出预防传经的方法，并对第4条的“传”也作了回答。

第9、10两条的内容，论太阳病的欲解时和太阳中风期待自愈的日数。它说明了正复邪退要有一个条件，应以时日对正气得旺而方欲解，它说明了时间和空间对疾病的影响，故具有临床意义。

以上计11条，皆有论而无方，其重点在于辨阴阳寒热，辨表病异同，辨病邪传变，辨病欲解时，它是全书纲领，也可作为《太阳篇》的总论。

第12条论太阳病的中风证，是在第2条的基础上补充了中风的病理和治疗方法。

应当指出，张仲景先抛出桂枝汤并非偶然之举，而是用以说明治病的原则在于调和阴阳。桂枝汤滋阴和阳故为群方之魁，它与第7条的辨病发阴阳同等重要。

第13条的内容，看来与12条好像重复，实际上本条不提中风而提太阳病，所以扩大了桂枝汤的治疗范围，它比12条有更深一层的意思。

第14、18、20、21、22、28等条，是论桂枝汤的加减证，它们的前后排列之法，很能启人深思。

作者先从第14条的项背强**几几**经输不利的桂枝加葛根汤开始；后以头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利的桂枝去桂加茯苓白术汤收尾。其用意是把太阳经输不利的表证列在前，太阳病腑证属里故列在后，从中把发汗和利小便的两种治法加以划分，以体现太阳病经腑不同治法的意义。

在桂枝汤加减证后，还穿插了桂枝汤的禁忌证，从正反两方面立论，而有利于桂枝汤的正确使用。

第15条内容论误下之后，太阳之气上冲和不上冲，不上冲的则禁用桂枝汤。对“气上冲”的解释不一，若与134条的“阳气内陷”互相对看，则知“其气上冲”，也就是未致阳气下陷的互义。

第16条的内容论“坏病”不能用桂枝汤，太阳病无汗表实脉紧的也不能用桂枝汤的道理。

第23、25、27三条论桂麻合方的证治，它以太阳小邪不解，或寒热如疟，或热多寒少，或不得小汗出身必痒。此时的治疗如单用桂枝汤则嫌其缓，单用麻黄汤则又虑其峻，故以两方合用，而又以桂枝冠首，则含有护正去邪之宗旨。

但是，第27条的“此无阳也”，注家意见颇不一致。我认为若以太阳表寒欲罢作解，则庶几近之。可参考153条的“无阳则阴独”句，据成无己注：“表证罢无阳”，则其义自见。

桂麻合方另一意义，作者有从《太阳病上篇》的桂枝汤证，到《太阳病中篇》的麻黄汤证作为引线之笔而有循序渐进的意思在内。

第29条，从表面上看是论桂枝汤的禁忌证，但它包含了对第16条“观其脉证，知犯何逆，随证治之”的补笔，具体地为随证施治作出了示范，至于第30条则是作为29条的注文而已。

二、《太阳病中篇》97条

《太阳病中篇》的条文为97条，从31条到127条。

第31、33条内容论葛根汤证及加味证。其中的31条应同14条作比较；32条又应同36条对比，然后可以审知项背强**几几**分有汗和无汗；二阳合病分下利与喘满的不同。至于34条的误下而利遂不止，又应同二阳合病必自下利互相对看，以辨下利一证而有表里寒热的具体不同。

第35条内容，是在第3条的基础上补充了伤寒无汗而喘和麻黄汤的治法。此条也应同12条的桂枝汤证作比较，以见有汗为虚，无汗为实的辨证方法。

第36、37条内容，继论麻黄汤证，但辨证的重点各自不同。36条从证以辨喘，37条从脉以辨浮，以见麻黄汤的治疗各有所本。

第38、39、40、41等条的内容，论麻黄汤的加减证，而具有表里兼治的特点。

38、39条是大青龙汤证，关键在于不汗出而烦躁；40、41条是小青龙汤证，关键在于表不解而心下水气。大青龙汤兼内热，小青龙汤兼

内饮，故两条排列无间，以资互相对比发明。

第42、43、44、45等条，接麻黄汤之后，又论桂枝汤证以代替麻黄汤治疗之不及。其衔接之处，如38条“脉但浮者，与麻黄汤，”若外证未解，脉浮弱者则不用麻黄汤，应以桂枝汤为宜。

第41条的咳而微喘是用小青龙汤，但43条的“下之微喘”，则不能用小青龙汤而用桂枝加厚朴杏仁汤，以示桂枝、麻黄在治喘上而各有不同。第44条内容论外证未解者不可下，从文推义当有不大便之证，治当先解其表宜桂枝汤，而禁用麻黄汤，恐其过汗伤津反助胃肠之燥故也。此条与下文的56条合参则意义更明。

第45条论汗下之余，脉浮不愈，乍看和37条的麻黄汤证相同，而此处却用了桂枝汤。作者考虑了汗下之后，已难胜任麻黄汤峻汗的缘故。

通过以上的条文可以看出，作者于桂枝汤后论桂麻合方；桂麻合方后又论麻黄汤；麻黄汤后又论桂枝汤。桂枝汤方虽一，而使用方法则因证而异。一般说无汗不用桂枝，而56条未提有汗一证，但也用了桂枝，文义愈述愈深，而桂枝汤之治，因之亦愈广。

第46条论服麻黄汤以后的证情，它与24条的服桂枝汤，反烦不解之义相同。然24条先用刺法，然后再服桂枝汤，而46条先服麻黄汤发汗而使正气拒邪外出，故继之作衄乃解。

第47条先论伤寒无汗，体强者有衄以代汗之机。若同35条麻黄汤发汗之治合参，以见汗血同源、殊途同归之旨。

第48条论二阳并病的成因，以及阳明经证、腑证的特点，与发汗不彻的脉证。若同32条相比较，以区别“合病”与“并病”的证候不同。

第49、50条论不可发汗之脉，第51、52条是论若其人尺中脉不微、不沉、不迟而浮数的，则仍可用麻黄汤发汗。虽然是言脉，而其证候亦包括在内。

第53、54条内容论桂枝汤营卫不和证，条文开头不冠风、寒，而以“病”称，说明此条与中风无关，而已涉及杂病的范围。

第55条内容，应与47条对比，以见伤寒作衄有解与不解之分。若衄少而邪不出者，则又当以麻黄汤发汗，越出营中之邪，则衄亦随之而愈。

第46条论先服麻黄汤病不解，而后作衄乃解；55条则是先衄不解，后用麻黄汤发汗则解；55条为不发汗因致衄；47条为身无汗而自衄者愈。这几条若不联系起来看，则首尾不顾，便觉索然无味。

第56、57条论用麻黄汤发汗，半日后病又复烦不解、或不大便六七日，头痛有热而小便清白，皆应以桂枝汤先解外邪，用代麻黄汤之治。

第58、59两条列于误治变证之前，是继辨病发阴阳之后，又示人治病能使“阴阳自和”方为愈病之宗旨。因此它对以下的60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70条等文，有其指导意义，而为救治“坏证”指出了原则。

从60条至70条的误治变证中：有内外俱虚的身振而寒；有阳虚阴盛的烦躁；有营卫俱虚的身疼痛；有肺热作喘，心虚作悸，脾虚作胀，水夹肝气上逆，脐下悸、欲作奔豚以及汗后恶寒为虚，不恶寒但热为实等表、里、寒、热、虚、实、五脏六腑等病证，反映了伤寒与杂病相互共论的辨证典范。

第71、72、73、74等条，论太阳病表里不解的蓄水证，它以口渴能饮而小便不利为主。此条作者用假宾定主的笔法，先论胃中干燥，烦躁不得眠，欲得饮水的缺津证，然后引出若脉浮，小便不利，微热消渴的蓄水证。一为缺津，一为津凝不化，两者病理不同，然证候易混，故对比分析，从中以见辨证之法。

第75条论发汗太重、心肾阳气两伤，以致心悸欲按而两耳发聋，当与64条的“其人叉手自冒心，心下悸欲得按者”作比较，以见证有轻重，而治有区分。

第76、77、78、79、80等条，论胸膈火郁的虚烦诸证。从病理讲水蓄于下，而火炎于上，故栀子豉汤证接五苓散证后有辨水火二证的思想。另一意义是太阳病由经传腑，则以蓄水为主；若由表传里，而邪必先胸，故有胸中火郁的虚烦证产生。火郁于胸则心中懊^懔懔；，如气不利则胸中窒，血不利则心中结痛；若下延入胃，则心烦腹满，卧起不安；若胸热而脾寒者，则大便必溏而又身热微烦。

第81条是论栀子豉汤的禁忌证。

第82条论阳虚而水气泛滥的真武汤证，也含有水下火上的辨证意义。

从83条至89条论不可发汗，是指麻黄汤的禁忌证而言。不可发汗，指其人虽病伤寒然夹有阴阳气血、营卫津液等正气不足之证，所以就不能发汗。如果强发虚人之汗，则有便血、发痉、不能啣、不得眠、寒栗而振等逆。若结合49条的“尺中脉微”和50条的“尺中脉迟”来看，则禁汗的脉证于是方备。

第90、91、92条论病有先汗后下之分，也有先下后汗之变，更有表

里缓急之治和“两感”风寒的兼治与专治之异。在禁汗之后，又提出什么是先治，什么是后治，什么是急治，什么是缓治，什么是兼治，什么是专治，确有总结以前、指导以后的科学意义。

第93、94、95三条并列，分析了三种不假药力而出汗的不同机制。93条的“冒汗”可责其虚；94条的“战汗”为邪已外解；95条的“自汗”为卫强营弱而邪风不去。三种汗出互相比较，以加强读者的辨证思维。

张仲景写到95条时，已把太阳病的经腑证治叙述完毕，发汗与禁汗亦无复可议，乃由太阳病而转到少阳病的证治。联系以前的二阳合病与二阳并病，从中可以见到太阳传入之邪，并不固定先传某经的具体事实。

第96条论邪传少阳的证候与治法，亦可同37条的“设胸满胁痛者，与小柴胡汤”之文合参。

第97条论血气虚衰之人，邪中少阳而搏于胁下，同96条对比有继发和原发的两种不同形式。

第98条论小柴胡汤的禁忌证，其病为湿、饮所伤，而类似少阳，实非少阳证，若与99条的小柴胡汤对比，则治疗宜忌自明。100条论少阳夹虚的证治，101条论治少阳证不必悉具，以及误下少阳而柴胡证不罢者，可复与小柴胡汤之理。

第102条论伤寒夹虚的小建中汤证，它既可与100条对看，也更应与第50条的“尺中迟者，不可发汗”相参，而补出小建中汤治虚人伤寒的方法。

小柴胡汤为柴胡剂加减方代表，所以，在小柴胡汤主证的前提下：103条论少阳兼阳明的大柴胡汤证；104条论少阳兼潮热的柴胡加芒硝汤证；105条论阳明谵语的胃燥内实调胃承气汤证；106条论太阳病不解，热结膀胱，其人如狂而少腹急结的桃核承气汤证。此条列于大柴胡汤之后，作者用意是胸胁满用小柴胡汤；心下急用大柴胡汤；但少腹急结者则用桃核承气汤。以示上焦气郁，中焦热结，下焦血瘀之辨，这种气郁与血瘀相提并论的写法则对人甚有启发。

第107条论柴胡加龙骨牡蛎汤，而排列于桃核承气汤之后的用意，为此证有胸满烦惊、谵语等精神证候，以资与蓄血如狂，少腹急结的桃核承气汤证对比区别，而后方知各自的病机特点所在。

第108、109条论肝胆之邪传脾、乘肺的变化，曰纵曰横，寓有气亢妄行无制之意。

从110条至119条论误用火疗的种种坏证，后汉时期此法施用为广，

故论其有弊于病的一面。至于其中的救逆汤、桂枝加桂汤、桂枝甘草龙骨牡蛎汤，在临床治疗中仍被广大医家所习用，而为人们所重视。

第120、121、122、123条文论太阳病误吐的变证。120条论吐后中寒；121条论吐后内烦；122条论吐后客热不能消谷；123条论太阳病极吐下、胃中不和而郁郁微烦。吐后共分四证，有寒有热，应互相对看，以尽辨证之长。

第124、125、126条论太阳之邪随经入里的热与血结证，应与106条的桃核承气汤证互相对比，以辨热大于瘀，瘀大于热，瘀热皆轻的三种病情。

第127条论太阳病蓄水证，若小便利的则为茯苓甘草汤证，以饮水多必心下悸；若小便少的为五苓散证，则饮水之后必苦里急。此条应与73条进行联系，其义方备。

三、《太阳病下篇》51条

《太阳病下篇》共有条文51条，从128条到178条。

第128、129条内容论结胸与脏结的证候。把结胸与脏结并列而论，是一种虚实对比的写法。又从结胸为实，脏结为虚，结胸为热，脏结为寒而互相对比发挥，以加强辨证认识。

第130条论脏结无阳证，131条论结胸与心下痞的成因。从脏结以论结胸不但是互相发明，又有假宾定主的含意。

第132、133条论结胸下之太早则死，然而当下不下使证情加剧亦死。两条一起体会，其义更觉突出。

第134条论误下热与水结的大结胸证与治法。文中的“阳气内陷”遥对第15条的“其气上冲”，以说明误下后的两种可能。若误下而不结胸，热与湿结发生小便不利的，则身必发黄，以辨同一误下，而有水结和湿郁的不同。

第135条论结胸三证：即脉沉紧，心下痛，按之石硬。抓住三证，以辨结胸，则做到心中有数。

第136、137条论结胸与大柴胡汤证、大承气汤证的鉴别分析，以免三证混为一谈。

第138条论小结胸三证，即正在心下，按之则痛，脉浮滑；应与135

条的大结胸三证对比分析，则大小之证自然分明。

第139条论其人本有水饮在内，若太阳之邪化热入里与饮相搏，则成结胸证；若不成结胸而下利不止的则为“协热利”。它说明了误下的一种原因而有两种发病形式。

第140条论凭脉测证之法，以寓误下诸般变证的发生。

第141条论用水疗以劫热，其热被劫不得去，以致稽留体表，而成皮下水郁之证。同时又论了寒实结胸的证治。

从上述的128、131、132、133、134、135、136、137等条来看，作者集中地论述了大结胸的病因、证治、禁忌、预后等一系列问题。至于129、130两条论脏结之成因，它详于证候而略于治法，所以，应视为属于结胸的类证。

第142条是论太少并病，因其证有“时如结胸”的特点，故列于结胸证之后，以资有所区分。第143、144、145三条论妇人热入血室的证治。此证与少阳有关，然又有“如结胸状”之特点，作者列于太少并病之后，而又与结胸证区分，其文法之妙，引人深思。

第146条论太少并病，147条论少阳病兼太阴脾寒证，148条论少阳证的阳微结而与纯阴结的分析，它示人少阳为病而变化多端的事实。

第149条论一证三变，辨证之法，引人入胜，并开心下痞证辨治之端。

第151条论痞证的特点，虽着墨不多，却是画龙点睛之笔。

第152、153两条，一论实证，一论虚证，但皆见心下痞，而又不属于主证之例，故可目为心下痞的类似证。

第154条论热痞，以关脉浮为凭。在热痞的前提下，而第155条又论汗出恶寒的上热下寒痞，两条相连，说明了辨证是相因而成。

第156条论水痞，辨证关键在于小便不利；157条论饮气之痞，它与水痞有内在联系，可以互相发挥。

第158条论脾虚客气上逆痞，其痞与利皆重，而又有心烦不安。心下痞为胃气不和之证，若不用泻心汤而误用下法，则使人下利不止。

为此，第159条针对下利，而出理中、固涩下焦、利小便等不同的辨证和治法。

第160条论水气痞而气血虚衰，久而不愈则成痿；第161条论痰饮挟肝气而成痞，且有噎气不除；第163条则论协热下利，心下痞鞭而表里

不解。

第164条论心下痞而表未解，应先解表，后治其痞；165条论肝胃气结的上吐下泻而心下成痞。

第166条论胸中寒的可吐证；167条论胁下素有痞的脏结死证。

从上述的149到167条，都围绕痞的证候，或在心下，或在胁下，或在胸中，或虚或实，或寒或热，或寒热相混，其中辨证分析，使人咀嚼不尽。

第168、169条论白虎加人参汤证，170条论白虎汤禁忌证，以反映太阳之邪既有传少阳之机，也有传阳明之可能，如追溯96条之文，则其义自明。

第171条论太少并病，第172条论太少合病。继白虎汤证又论少阳，以示传入之邪因人而异，本来无定之义。

第173条论胸热、胃寒而不成痞，说明病机相似而症状不同。

第174条、175条论寒湿痹痛，是属伤寒的类证，也是伤寒与杂病共论之文。

第177条论伤寒脉结代，心动悸，以示病虽始于太阳，终累及于少阴，以见阴阳表里相配之义。

四、《阳明病篇》84条

《阳明病篇》共有84条。从179条到262条。

第179条论阳明病的里实证，其原因虽有三，而以正阳阳明为主。

第180条论阳明病的提纲证是胃家实。意在言外，若辨出了阳明病的“实”，则就达到辨证的要求。

第181条论阳明病的成因；182条论阳明病的外证；183条论阳明病而无所复传；184条论阳明病始虽恶寒而后即反汗出恶热。这四条具有阳明病以里实为核心的各种特点。

第185条论发汗不彻邪传阳明，若已传阳明则见濇濇汗出；186条是针对183条的“病有得之一日，不发热而恶寒”；184条的“始虽恶寒，二日自止”；故接着又称“伤寒三日，阳明脉大”。

从179条到186条乃是阳明燥热为病的总论，作者强调了阳明里证的

不大便和外证身热汗自出而不恶寒为眼目。

第187条论阳明与太阴相表里，有从湿化和从燥化的两种病理变化；188条接186条言若伤寒之邪系于阳明而不犯脾，则其人可见濇濇然汗出。

第189条论阳明中风而邪气浮泛于外的故不能下；188条对比之下是邪已传里，故濇濇汗出而不恶寒。

第190条以能食不能食辨中热和中寒，可以体会作者有意把伤寒与杂病并论的这一事实。

第191条论阳明中寒不能食，而不是燥屎内结的不能食；是中气虚的手足濇然汗出，而不是胃实的手足濇然汗出；虽然大便鞭，但只是初头鞭，而后必溏。这是欲作“固瘕”的表现，非是阳明病胃家实，此条从杂病角度对比伤寒胃家实之法。

第192条论阳明病的寒湿等证，若胃气复，谷气胜，则有汗出作解之机。

第193条论阳明病欲解时，而列于“谷气胜”之后，则有正复邪退之义。

第194条从不能食和脉迟以辨阳明胃气虚，故不可用下，应与191条合参。

第195条论阳明病脉迟的谷疸，虽下而腹满如故。第196、197条论阳明病有汗则为实，无汗反为虚的机理。可见阳明病中，亦有寒证、湿证、虚证，并非只论伤寒一病，亦兼论杂病。

第198条，论阳明病的火邪上炎，199、200条则论湿热发黄之证。

第201、202、203、204、205等条论阳明热在外而未入里，因其里未实故禁用攻下。

第207条论阳明病可下的轻证，应同208条互相对比。

第208条论燥屎可下，在于它有潮热；若其热不潮，即使腹胀而大便不通，也不能用大承气汤，只能用小承气汤微和胃气。

第209条论阳明病有潮热，如大便鞭时方可下，以补208条的未了之义，以及测验大便是否成燥，是水到渠成的笔法。为此，第208条与209条合而观之，方尽其义。

第210条论阳明实则谵语，然忌阴竭于下的直视、喘满与下利；211条又补出谵语，又忌见正虚的脉短之候。

第212条论大承气汤证及当下不下的循衣摸床，惕而不安证的预后和转归。

第213、214条论汗多胃燥，便鞭谵语，病变在津液伤与胃中燥之间；或谵语潮热、脉不沉实而反滑疾者，均宜以小承气汤代替大承气汤治疗。

第215条承上条继论谵语、潮热而反不能食，反映了肠实胃满燥屎已成；同194条对看，若能食，主大便虽鞭而未成燥屎。燥屎已成则用大承气汤，未成燥屎的则用小承气汤。

第216条论阳明在经之热不解，而有热入血室之变，它也同以上条文，同是论妇人之病。

第217、218条论阳明病兼经邪不解，过经者方可下；若阳明病脉沉而喘满，为病在里，则不可反发其汗。两条合参，以见阳明病汗下之尺寸。

第219条论三阳合病而热盛者治用白虎汤；220条论二阳并病，阳明已成实证的治用大承气汤；221条论三阳合病，而热在膈脘的治用栀子豉汤；222条继上条，若见热在中焦而渴欲饮水的治用白虎加人参汤；223条承上条，若热在下焦而小便不利的则用猪苓汤。以上诸条，反映了仲景设法御变，而不拘一格。后世医家称为“阳明病开手三法”，总为热盛而不成实的设法。

第224条则论猪苓汤的禁忌证。

第225、226条论脉浮而迟，表热里寒之证，似与上述之阳明病热证有互相比较之用意。

第227条论阳明病热在经则作衄；228条论阳明病热在上则心烦头汗出；229条论阳明之邪不实而少阳之邪犹在；230条论阳明病虽不大便，然舌苔不黄而胁下满的，则病不属阳明而仍属少阳的分析。以上诸条皆为阳明热证而未成实之辨。

第231、232条论三阳合病，脉弦浮大的，有刺阳明、解少阳以及发太阳之汗的各种辨证。

第233条论阳明病津液内竭者，不可攻下而可外导的辨证方法，应与承气汤证对照而看。

第234、235条论阳明病经表之邪不解，而有桂枝、麻黄两方之治。

第236条论湿热发黄证治，若与燥热之证对比鉴别则辨证更为突出。

第237条论阳明病蓄血其人善忘，可与太阳病的蓄血发狂证合观。

第238条到242条，论阳明病可攻与不可攻的辨证。

第243条论胃寒作呕；第244条论误下成痞，以见病邪或转阳明，或为蓄水的辨证方法。

第245条论汗出太多，阳绝于里，亡津液于外，大便因鞅，而含有论脾约之成分。

第246条继上条论阳绝于里之脉，247条论脾约的证治。以上三条皆论亡失津液而阳热阻绝于里的病变。

第248条论阳明胃燥的蒸蒸发热，249条论吐伤津液的腹胀满，治法皆须用调胃承气汤以和胃气。

第250条论阳明病不大便，微烦，小便数，大便因鞅的小承气汤证。

第251条论阳明病屎虽鞅而未成燥，以其尚能食，故以小承气汤微和之。若服后仍不大便则可制大其服，与小承气汤一升。凡用大承气汤时，须小便利，屎定鞅乃可攻之。

从248条到251条，是论可下之证，然有在胃在肠、成鞅成燥之分，故三个承气汤交相穿插分析，使人增强辨证论治的水平。

第252、253、254条论阳明病三急下证，为急下存阴，泻燥全水之法，但辨证重点在于救阴。可见阳明病延误病机，每以亡阴而告败。

第255条论腹满不减的可下证；256条论阳明、少阳合病而大便必下利，及其脉不负为顺的机理；若脉滑而数，为阳明气实内有宿食，则当泻下而解。

第257条论阳明热与血瘀的发热不解证治，应与237条的“本有久瘀血”对比合参。

第258条论阳明热迫于肠而下利脓血，是同257条同一原因所发生的两种病变。

第259条论寒湿发黄不可下；260条论湿热发黄而里实腹满则可下。两条排列而有对比之意。

第261条论身黄发热的栀子柏皮汤；262条论伤寒瘀热在里，身必发黄的麻黄连轺赤小豆汤证。

第260条论湿热在里，262条论湿热在表，261条论湿热非表非里，故三条合看，方尽其治。

五、《少阳病篇》10条

《少阳病篇》共有10条，从263条到272条。

第263条论少阳病的腑证提纲，故以热证的口苦、咽干、目眩为主。

第264条、265条论少阳之经或中风或伤寒的脉证。少阳经介于表里之间，故治疗禁用发汗与吐下。

第266条论太阳之邪转入少阳的证候和治法。

第267条论误治少阳发生的“坏证”，应与264、265条的“坏证”同看。

第268条论三阳合病而热在少阳的盗汗证；269条论伤寒六七日邪从少阳之枢，有阳去入阴的机转。

第270条承上条论三阴不受邪侵，以其人能食而不呕，反映了胃阳强而不衰。

第271条论少阳邪解之脉，272条论少阳欲解之时，两条相联系以见少阳欲解的脉时依据。

少阳病的大部分内容已在《太阳病篇》第96条至第108条进行了论述，因此，可与有关条文加以参考。

六、《太阴病篇》8条

《太阴病篇》共有8条，从273条到280条。

第273条论太阴病的提纲证，应与阳明病的胃家实对比，以见寒热虚实反映在脾胃上各自不同的证情。

第274与276条合看，是论太阴经表的证治。

第275条论太阴病的欲解时，列于274条“阳微阴涩而长者，为欲愈”之后，有正复邪退，相互借助用意之处。

第277条论自利不渴属太阴，应与282条的“自利而渴者，属少阴也”，互相对看。

第278条论太阴湿热发黄的脉证和脾家实、湿浊作解的机转。

第279条论脾家气血不和的腹满时痛和转阳明的大实痛的证治。

如果把277、278、279合在一起体会：作者先论寒，后论湿，再论实，以体现太阴为病的层次。

第280条论太阴病大便利而脉弱的腹满疼痛时，则以减去大黄、芍药为宜，因其人已是胃气虚寒之故。

七、《少阴病篇》45条

《少阴病篇》共有45条，从281条至325条。

第281条、282条论少阴病的提纲，而以阴阳两虚的脉证和阳虚不蒸腾津液的病理变化为主。

第283条论少阴病寒盛亡阳；284条论少阴病被火气劫伤阴；285条论少阴病阴虚禁汗；286条论少阴病阳虚禁汗与禁下之脉。以上四条论述了少阴病有治疗之禁，应从阴虚、阳虚两个方面加以理解。

第287条论少阴病阳回寒去；288条论少阴病利止，手足转温；289条论少阴病阳回，时自烦欲去衣被；290条论少阴病脉阳微阴浮而为欲愈。以上四条论少阴病阳气恢复，阴寒消退的欲愈佳象。

第291条论少阴病欲解时，所以列于290条之后，其意义则与太阴病同。

第292条论少阴病吐利、手足不逆冷，反发热者不死；第293条论少阴之邪外出太阳，而一身手足尽热，以热在膀胱必便血。两条皆有身热，但有阳气复和邪气外出的不同。

第294条论少阴阳虚但厥无汗，若强发其汗，必动其血，可构成小便难而口鼻出血的“下厥上竭”的生命危险。

第295条论少阴病，身蜷而利，手足逆冷；第296条论吐利烦躁，四逆；第297条论下利止，而头眩，时时自冒；第298条论四逆恶寒而身蜷，脉不至，不烦而躁；第299条论少阴病六七日而息高；第300条论自利，复烦躁不得卧寐。以上诸证，反映了少阴阴寒内盛，阳气已败，真气已竭的死证。我们从各个证候的特点而分析出其所以构成死证的原因和证情，以提高理论水平。

归纳起来，从281条到300条属于少阴病的总论部分，它阐述了少阴阴阳水火升降出入的病理变化和证候特点，以及阴阳盛衰、正邪进退和有关预后的问题。所以，它是少阴病的辨证纲领。

第301条论少阴病始得之而太阳表邪不解的“两感”证。可与92条的病发热头痛、脉反沉合看，以见太阳与少阴为表里的关系。

第302条继论301条的证候，若延至二三日，而无少阴里寒时，仍可微发其汗的治则。

第303条论少阴阴虚热证，而以心中烦，不得卧之证为主，从中可以体会少阴为病内关于心肾的事实。

第304、305条论少阴病的附子汤证，它一治少阴阳虚背部恶寒；一治少阴阳虚骨节痛而手足寒。背为阳之府，四肢为诸阳之本，故以两条的寒象，以辨少阴阳气之衰。

第306、307、308条皆论少阴病下利脓血，其中有寒热之别和涩肠止利与泻热止痢之分。

第309条论少阴病吐利，以吐为主证的吴茱萸汤证，应与378条对比，则其义自明。

第310条到313条论少阴病的咽痛。少阴之经脉“其直者，从肾上贯肝膈，入肺中循喉咙”，故少阴为病而又有咽痛的特点，以及寒热不同的证治。

第314条论少阴病下利的白通汤证；315条论服白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦者，反映了不但伤阳且也伤阴，应与白通汤加猪胆汁阴阳两顾，也示范“从治”之法。

第316条论少阴病阳虚水泛的真武汤证；317条论少阴病里寒外热的格阳证。

第318条论少阴病阳郁不伸的四逆散证，应与少阴病阳虚寒证作比较。

第319条论少阴病阴虚有热的蓄水证，可与316、303条对看：比水分寒热，比证分阴阳，比火上水下的心烦不得眠。

第320、321、322条论少阴病的三急下，应与252、253、254条合观，以见燥热伤阴急下的角度各有不同。

第323条论少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。此条列于急下之后，以同燥热亡阴互相对比而各有所重。

第324条论胸中痰实和膈上有寒饮证治；325条论呕而汗出，必数更衣的证治。这两条有虚实之分，故其呕吐之证也有所区别，亦可同166条合参。

八、《厥阴病篇》58条

《厥阴病篇》共有56条，从326条到381条。

第326条论厥阴病的提纲证，它以风阳之气上撞于心，心中疼热；又以脾胃虚寒，食则吐衄，下之利不止的寒热错杂证候为主。

第327、328、329条论厥阴欲愈的脉、时、证，其义同于上。

第330条论阳虚寒厥，不可下之，应同335条的“厥应下之”合参。

第331条论厥阴寒厥，后见阳复发热，则下利必自止，如又见厥，则复又下利。

第332条论热与厥的胜复情况，以及阳热太过而不罢者，必发痈脓。

第333条论太阴中寒，而误用黄芩汤，其腹必冷，若反能食者，名曰“除中”，预后多为不良。

第334条论厥热胜负，若阳复太过而反汗出，则发喉痹；若发热无汗，则利下不止，必便脓血。此条应与332条合看，以证明热气伤阴而有在上、在下、在外之分。

第335条论阳热厥的前热者后必厥的证候与治法。此条应与354条的阳虚寒厥对比，也应同330条的“诸四逆厥者，不可下之”合看。

第336条仍论厥热胜复的辨证。然“厥终不过五日，以热五日”，厥热相平，故可断其自愈。

第337条论厥阴的病机和症状。此条与第7条、第58条的阴阳辨病证、阴阳辨病机、阴阳辨治法成鼎足之势。

第338条用宾主的笔法写出脏厥与蛔厥的分析和蛔厥的证治方法。

第339条论热少厥微的病欲愈；与厥而呕，胸胁烦满的其后必便脓血。

第340条论冷结在膀胱关元的小腹满而手足厥冷。

第341、342条论厥热胜复的热不除，以及寒多热少的阳气衰退之证。

第343、344、345、346条论阴盛绝阳的死证，其中示人有应顾护阳气于先的意义在内。

第347条论脉虚复厥不可下，应与第330条合参则明。

第348条论发热而厥，七日下利的难治之证。

第349条论寒厥可灸；第350条论热厥可清；第351条论血虚寒厥而可温的各种治厥方法；第353条、354条论阳虚寒厥治法；第355条论胸中实致厥的治法；第356条论心下水气致厥治法；357条论邪郁于里，寒热错杂的厥利治法。

以上诸条论厥的证治，应当对比分析，以见辨证之精。

第358条论寒利的前驱证候；第359条论食入口即吐的证治。

第360、361、362、363、366、367、368、369条，论下利预后的生死诊断。

第364条论下利清谷，不可攻表；第365条论下利所见之脉不同，而其病机也随之不同，是为以脉验证之法。

第370条论下利清谷，里寒外热的治法；第371条论热利下重的治法，两条应加对比，以分清寒热下利之证。

第372条论里寒与表邪的治则，应与第91条合参。

第373条论厥阴热利的证治；第374条论热结旁流的证治；第375条论下利虚烦的证治。

以上从367条到375条皆围绕下利问题，或辨其预后，或辨其寒热虚实以及相应的各种治法。

第376条论因内痈致呕，治痈而不治呕之理，此条应与第19条同参。

第377条论里寒外热之呕；第378条论肝胃寒饮上逆之呕；第379条论脏病还腑之呕。

从376条到379条皆围绕呕的问题加以辨证论治。

第380条哕而有虚实之分，第381条论六腑邪实之哕。虚与实对比成文，使读者从中加强辨证认识。

九、《霍乱病篇》10条

《霍乱病篇》共有10条，从382条到391条。

第382条论霍乱病的证候特点，在于呕吐而且下利。

第383条论霍乱除吐利外而有发热、恶寒等表证。

第384条论伤寒与霍乱的鉴别诊断。

以上三条是霍乱病的提纲证，而有指导临床之作用。

第385条论阳虚阴盛脉微复利，若利自止者，则为亡血伤津，为阳虚及阴的反映。

第386条论湿霍乱和寒霍乱的不同治法，以欲饮水和不欲饮水为辨证的依据。

第387条论吐利止而身痛不休的治法。它和吐利不止的五苓散证有对比发明的意思在内。

第388条论阳虚吐利汗出，手足厥冷的治法；第389条论既吐且利，内寒外热，脉微欲绝的治法；第390条论吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解的阴阳两虚的证治。此条应与第385条对比，以见亡血伤津的不同治法；第391条论吐利已复，新虚不胜谷气的小烦之证。从385条至390条皆有论有方，而有各论的意义在内。

十、《阴阳易瘥后劳复病篇》7条

《阴阳易瘥后劳复病篇》的条文共7条，从392条至398条。

第392条论伤寒阴阳易之为病的证候特点 and 治疗方法。

第393条论大病瘥后劳复和食复证的治法，虽叙证不多，以方推证当有烦热之变。

第394条论伤寒瘥后更发热的几种不同的证治之法。从392条至394条论伤寒后的饮食、男女、操劳、复感引起发热等的各种治法，使人读之有味。

第395条论大病瘥后，腰以下有水气的证治；第396条论大病瘥后，气虚而胸上有寒的证治；第397条论伤寒瘥后，虚羸少气，气逆欲吐的

虚热证治，一寒一热，极尽对比发挥之能事。

第398条论病人脉已解，而日暮微烦，属于脾胃气弱，不能消谷所致，故毋庸治疗，而损谷则愈。这说明了大病愈后应注意饮食问题，而带有普遍的意义。

十一、小结

总之，《伤寒论》的398条有经有纬，发生着纵横的联系。或互相补充，或互相对比，或互相发明，做到了文以载道，以尽辨证论治之能事。为此，凡是学习《伤寒论》者，就必须弄清其条文的编排目的和意义，从而才能登堂入室，以窥仲景著书的精神实质，而使学习《伤寒论》有更大的收获。

第三讲 试论六经为病提纲证的意义

六经为病的提纲证，是《伤寒论》辨证的纲领。六经为病，各有一条纲领，古人以之比如大将建旗鼓，使士卒望之而知趋，方能压住阵脚，而能指挥若定。观张仲景于复杂的疾病中，择出六经至当的证候，即所以建旗鼓，用以反映疾病的规律，使人知所趋。由是观之，六经的提纲证，具有十分重要的意义。

为了说明六经的提纲证，首先必须弄清六经辨证的对象和范围。我认为，六经辨证方法，原是以邪气伤人而立论的，并非只针对伤寒之一病。

柯韵伯在《伤寒论翼》的序言中说：“原夫仲景之六经，为百病立法，不专为伤寒一科。伤寒杂病，治无二理，咸归六经之制节”。柯氏把六经辨证，视为百病而立，实能先获张仲景之心，因而也就扫清了只治伤寒一病的俗见，扩大了六经辨证的范围。简而言之，这部书包括了两类疾患：一类是急性热病的伤寒，一类则是慢性疾患的杂病。两者发病虽异，而医理则通，都不能离开六经之节制。所以本书的内容是以六经辨证为宗旨。

六经本身是由脏腑经络所组成的六个系统，它们属于物质范畴，故有自身的运动规律，以反映生理和病理的变化。辨证的方法，就是按照六经的客观规律去分析疾病，去认识疾病，务使主客观统一起来，就达到辨证之目的。

然而，辨证一定要言之有物，丝毫不能离开物质的存在，六经绝非空洞的名词游戏，它既有受邪之体，又有所病之因。有能有所，以见证由体生，证由体定之理。因为辨证之法是从六经之体而求证，由于六经之体各异，故每经的证候特点也就随之不同，这就为辨证时创造了有利条件。但也应该看到，六经所反映的证候，又有共同规律可循，这是因为证候的产生，决定于六经的阴阳对立变化的规律。所以，阳与阴对立，有阳证也就必有阴证；表与里对立，如有表证也就必有里证；寒与热对立，若有寒证也就必有热证；虚与实对立，故有虚证也就必有实证。这种相对而生的八个证候，它们既是疾病中的阴阳矛盾产物，又是疾病对立的统一。因为它们不超出相对而生的阴阳、表里、寒热、虚实

的发病规律，古人就叫做“八纲”辨证。

八纲辨证是源于六经的，两者的关系只是有体用之分，而没有本质的不同。懂得了这个道理，对六经与八纲辨证的结合就打下理论基础。

以上介绍了六经辨证的意义和八纲辨证的关系，它为讲述下文提供了方便。

一、太阳病的提纲证

太阳，指的是足太阳膀胱经，吴崑说：太阳有敷畅阳气的作用，其气向外，故主表而又主开。

表，指人体的表层，包括了皮毛、腠理的部位。太阳之脉上达风府，下达腰肾，藉赖肾督的阳气资助，故为诸阳主气，而能总六经、统荣卫，为一身之外藩。

《灵枢·本脏》说：“肾合三焦膀胱，三焦膀胱者，腠理毫毛其应”。说明了人体的水脏、水腑、水道的气化功能，而有敷布气、津，充养于体表，起到既滋润而又温煦的双重作用。为此，凡风寒等邪犯表，则太阳必首当其冲。此时正邪相争于表，故其证候表现正如第1条（据赵本《伤寒论》条文号码为准，下同）所说：“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒”。柯韵伯对此条认为“观五经提纲，皆指内证，惟太阳提纲，为寒邪伤表立”。由此可见，本证的脉浮，是邪客于表，气血向外抗邪的反映，所以它是表证的纲脉；头项强痛、恶寒则是表证的纲证。能把脉证都提高到“纲”的高度去指导临床，就有辨证论治的作用。现在，先说太阳病的纲脉——浮脉。浮脉主表，这是人人皆知之事，但要提高到表之纲脉认识，则不见得受到人们的重视。请看本条是先论脉而后论证，脉在证之先，就反映了脉的重要地位。比如说；患者有头痛、恶寒的症状，看来很像表证，如果其脉并不浮的，就很难说它是太阳病，当然也就不能采取发汗的治法。由此说明，凭脉辨证，脉在证先，也是不容忽视的。为此，凡已经切到了浮脉，那就不论它是什么病，也不要管病程多久，都应先考虑这个病是否为表邪不解？抑或由于表邪不解所引发的各种疾患，必须认真分析，千万不要发生差错。然而，浮脉也有不主表的时候，那属于另一个问题。但是，必须立足于表证而进行分析，才不至于迷失方向。

我在浮脉主表的问题上，既有经验又有教训，记得过去看过一个头

痛发热的病人，切其脉浮，这本是外感的发热，此时轻轻一汗就会治愈的，然而，由于我对浮脉主表这个纲没能抓好，所以就没用发汗解表之法，反误用了一些寒凉药品，结果造成了误治。类似这种情况，尚不止个人，故有总结之必要。

吃一堑，长一智，经过这一教训，方使我逐渐明白了自己的错误，而对浮脉主表的实用价值更有切身的体会。从此，我在浮脉主表的理论指导下，治疗过水肿、气喘、痛痹、痒疹等证，皆按表证发汗之法取得了疗效。也只有通过正反两方面经验教训以后，我才对太阳病“浮”为表之纲领有了新的认识。

“头项强痛”的出现，和太阳受邪以后经脉气血不利有关。《灵枢·本脏》说：“经脉者，所以行血气而营阴阳，濡筋骨而利关节者也。”故太阳经脉受邪，可出现头项强痛之证。然而，三阳经皆上走于头，惟太阳经，独络脑下项，为其所专，故以“头项强痛”为太阳病的证候特点。另外，太阳主表，而表又莫高于头，故反映表邪，较它处而实为灵敏。例如第8条说：“太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也”。张仲景以头痛与否，测知经邪的去留，就说明头痛的重要性。如推而言之，《伤寒论》提到头痛一证的，不下11处之多，其中属于太阳病的就占了9处，这也说明了头痛确是太阳病的一个重要标志。至于“恶寒”则是表证的最后一证。它是卫阳被伤，不能温煦肌表的病理反映。根据伤寒学者们的研究，凡文中“而”字下的证候，都带有关键的意义。如“无汗而喘”的“喘”，“不汗出而烦躁”的“烦躁”等证皆是。所以“而恶寒”的“恶寒”，就成为表证的关键。

古人说：“有一分恶寒，便有一分表证”，凡症见“恶寒”的往往意味着表不解。正如第164条说：“伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也”。查本条是在“叠经治疗”之余，而恶寒一证仍在的，就不能先治其痞，而应先解其表，因为恶寒不罢，是表证未解的原故。返回来，再看第48条的说法：“二阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒，……”这里说的“不恶寒”，反映了表邪已罢，而病由表入里，内传阳明。这就说明作者根据以上两条的“恶寒”去留，而关系到或汗或下之分。为此，抓住“恶寒”的表证之纲，确有指导临床之价值。

综上所述，太阳病的脉证提纲，确有强烈的现实意义。但是，又应该看到，脉证之间并非孤立的，而有其相互联系，如其人脉浮，又应有头痛，或者是恶寒。故不可把脉证孤立起来看待，这样，方有利于辨证论治。

二、阳明病的提纲证

阳明，指的是足阳明胃经。两阳合明名曰阳明，吴崑说：阳明有受纳阳气的作用，其气向里，故主里而又主阖。里，在此指胃肠，它是燥热之邪，内与糟粕相结，而不能排出体外的病变。

第180条说：“阳明之为病，胃家实是也”。此条张仲景不以证候为纲，而以“胃家实”的病理为纲，其涵义包括：一是阳明病所包之证为广，非片言只语所能道尽；二是张仲景有意识突出了一个“实”字，让人辨证从阳明病实证入手，因为只要辨出实证，也就达到了抓纲之目的。清人尤在泾有感于张仲景胃家实的提法，他说：“盖阳明以胃实为病之正，以攻下为法之的”。他的话一锤定音，道破了阳明病的要害。

阳明胃属腑，其生理功能是传化物而不藏。即饮食入胃则胃实，通过胃的腐熟和消化，则使代谢物下移于肠，此时则肠实而胃虚，只有始终保持这种胃肠的虚实交替的程序，才符合阳明腑以通为顺的生理。若胃肠燥热，而使津液干涸，糟粕结滞，变成燥屎而不能排出体外，这就使肠实而胃满，腑气不得通顺畅达，则可形成阳明病的燥实诸证。

由此来看，阳明病是因热成燥，因燥成实，故有大便秘结不通的发病特点。大便既然不下，故又可产生腹满不减，绕脐作痛，疼痛拒按等腹部症状，这也是胃肠实证的必见之候。

阳明既燥热内敛，则阖势已成，势必逼津外出，或见于手足濇濇然汗出，或腋下汗出如洗，或逼津偏渗而小便反数，抑或逼津下渗而大便下利清水，色纯青而味极臭秽。津液被劫而外亡，肠胃更无以滋，则大便转燥转甚，故为燥屎已成之征。燥屎虽不能出，然腑气时转，故又有“转矢气”的证候特点。

阳明为盛阳，抗邪力强，若胃气与燥热相争，每于申时则发潮热。潮热，热来有信，按时而至。此热一见，则大便每多成燥。夫胃络于心，心主神志与语言，故阳明燥实之证，多见神昏谵语等候。总的说来，阳明病以实证为主，故以不大便、腹满疼痛、热迫津流、矢气潮热、神昏谵语为辨证根据，其脉则以紧而有力，或沉迟有力，舌苔则见黄燥，或生芒刺为准。

通过以上的证候，反映了阳明病以胃家实为主，这样才能突出阳明为病的特点，从而也达到了阳明病提纲证的具体要求。

三、少阳病的提纲证

少阳，指的是少阳胆经。少阳位于胸胁，居于表里之间，叫做半表半里部位，它能转输阳气，犹如枢轴，故少阳之气主枢。

少阳胆而附于肝，内寓相火，性喜疏泄。若少阳受邪，则气郁而火动，迫使胆液上溢则口苦，消灼津液则咽干，风木上扰而为目眩之证。正如第263条所说：“少阳之为病，口苦，咽干，目眩也”。少阳病的提纲证，而以口苦在前，咽干、目眩在后，反映了口苦在辨证中的重要性。《内经》说：火之味苦，然它经之火，甚少口苦，惟肝胆有火，则多见口苦，故口苦反映少阳的邪热有现实意义。然口苦的证候，在于医生的问诊，如不问，病人往往不说，临证之时，望勿疏忽。咽干与目眩，临床易被轻视而不察知，殊不知它的辨证意义是极为重要的。

余曾治一慢性肝炎患者，审有口苦与胁痛，服用小柴胡汤。一日患者语余曰：服药后胁痛等证大减，且头晕目眩之疾，竟同时得瘳。从此方知仲景所列之提纲证，无一不从实践中来，洵非虚语。

四、太阴病的提纲证

太阴，指足太阴脾经，脾居中州，运化水湿，它有敷布阴气的作用，故太阴之气主开。

太阴为病，脾阳不运，寒湿内困，发为腹满，呕吐，腹中冷痛，大便作泻，而饮食不下。正如第273条所说：“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之必胸下结鞕。”夫阳明与太阴为表里，阳明主阖，其大便秘结而为实证；太阴主开，其大便作泻而为虚证。阳明病之腹满疼痛，在于大便之不通；而太阴病之腹满疼痛，则在于大便之下利。然三阴经病，皆有利，惟“自利不渴者，属太阴也”。故太阴病，虽吐利互呈，然必以大便下利，方为太阴病的提纲证。为此，在临床上不论什么病，及其时间多久，凡见到腹胀满而又下利益甚的，应先考虑太阴虚寒为病，则庶几近之。

五、少阴病的提纲证

少阴，指足少阴肾。吴崑认为：少阴若精气充满，则脾得其禀而能开，肝得其助而能阖，故少阴之气主枢。

病至少阴，累及根本，阴阳两伤，故脉来微细，而症见精神不振之“但欲寐”。正如第281条所说：“少阴之为病，脉微细，但欲寐也”。夫微主阳虚，细主阴虚，微在细前，反映了少阴病虽阴阳两虚，但以阳虚为主。“但欲寐”指欲睡而又不能熟睡，为阳虚阴盛之象。尤在泾说：“夫少阴者，三阴之枢也，阳于是乎入，而阴于是乎出，故虽太阴、厥阴同为阴脏，而其为病唯为少阴为然……仲景特举此者，以为从阳入阴之际，其脉证变见有如此。”由此可见，阳证变阴，传入少阴，则阳脉之浮而大者，则转为微而细，而目不瞑者，则转为但欲寐矣。用此以辨少阴伤寒，而更为紧要，切不可忽视。

曾治一位唐姓患者，年逾古稀，冬月患外感，头痛发热，鼻流清涕，自服成药羚翘解毒丸，前后共进六丸。感觉精神疲惫，手足发凉，乃挽余诊。持脉未久，患者即侧头合目思睡，其脉不浮而沉。余告病家曰：老人阳虚，又屡进辛凉之药，则使肾阳先拔，而阴霾用事，恐生叵测，乃急投四逆汤补阳消阴，其病得愈。

从此例看，“但欲寐”诚少阴病之提纲证，古人信不我欺。为此，临证之际，无论何病，凡切到微细之脉，见到欲寐之证，便可断言，病已由阳入阴，由盛转衰，而急温少阴之法，则不得失之交臂。

六、厥阴病的提纲证

厥阴，指足厥阴肝。“两阴交尽，名曰厥阴。”吴崑说：厥阴有受纳阴气的作用，故厥阴之气主阖。

柯韵伯说：“两阴交尽，名曰厥阴，又名阴之绝阳，是厥阴宜无热矣。然厥阴主肝，而胆藏肝内，则厥阴热证，皆少阳相火内发也。要知少阳、厥阴，同一相火，相火郁于内是厥阴，出于表为少阳”。以上可见，柯氏只说出了厥阴热证的一面。然厥阴为病，似又不能尽属热证。何以见之？因为厥阴病是病发于阴，故不能离开阴寒而成阳热。所以，这个病正处在阴尽阳生的阴阳转化阶段，阴未尽消，阳未尽复，而进退于阴阳之间的一种病变。它以寒热错杂的证候表现，而形成厥阴病的独自特点。厥阴的厥字，有“尽”和“极”的意思，它的阴寒已到了极点，而阳气也到了极衰的地步。然而，事物到了“极”就会发生由量变到质变的“突变”，古人也叫“物穷必变”，意思也差不多的，所以说“极”是事物

变化的内在条件。如果不懂这个道理，见到了“变”就不知其所以然，也就不能用辩证法的思想去指导实践。为此，厥阴病在它的阴寒至极之时，也就开始向衰退方面转化，而与阴寒相对立的阳气则反由衰的方面向来复的方面发展。由于阳气一直受阴寒所压抑，当它的来复也必然表示强烈。正如第326条所说：“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热……”等证，它反映了厥阴的相火和风阳之邪的汹汹之势。然此证同时又有“饥不欲食，食则吐蚘，下之利不止”的阴寒未消和脾胃虚寒的病理特点。因此，这个病既不可目为全热，又不得认为全寒。它应是阴阳错杂，寒热混淆的一种疾病，方为正论。固然在厥阴病中亦有单一的热证和寒证，惟其提纲证，则为寒热两兼而缺一不可。为此，凡临床见到的肝热脾寒，或上热下寒，寒是真寒，热是真热，又迥非少阴之格阳、戴阳可比，皆应归属于厥阴病而求其治法。昔者张卿子曾说：“尝见厥阴消渴数证，舌尽红赤，厥冷脉微，渴甚，服白虎、黄连等汤皆不救。盖厥阴消渴皆是寒热错杂之邪，非纯阳亢热之证，岂白虎黄连所能治乎？”

由此观之，临床见到阳证阴脉，或阴阳之证杂见，而又有气上冲心证的，皆应抓住厥阴纲领以求辨治之理，则就起到提纲挈领之目的。为此，我认为学习六经病的提纲证，不但要从理论上进行学习，而更重要的是从病人发病规律去进行研究。经过多次的实践检验以后，才能体会出六经提纲证的科学价值和临床指导意义。

六经病的提纲证是辨证的关键，它有系统规律可循。它把398条的辨证方法，而统属于六经提纲证之下，这对学习全文起到了纲举目张的效果，所以，它的科学成就实不可低估。

第四讲 《伤寒论》的气化学说

研究《伤寒论》六经辨证的理论是很多的。其以标本中见的理论去指导六经证治的则称之为气化学说，这个学派的代表则有张隐庵、陈修园等人。气化学说源于《内经》的运气学说，经过伤寒家们的移植和发挥，用以说明六经六气标本中见之理，以反映六经为病的生理病理特点而指导于临床。

为此，阐述这一学说时，必须先从《素问·六微旨大论》谈起。它说：“少阳之上，火气治之，中见厥阴；阳明之上，燥气治之，中见太阴；太阳之上，寒气治之，中见少阴；厥阴之上，风气治之，中见少阳；少阴之上，热气治之，中见太阳；太阴之上，湿气治之，中见阳明。所谓本也，本之下，中之见也，见之下，气之标也。”由于以上的阴阳六气标本理论的建立，就为伤寒学六经气化学说提供了理论上的根据（图1）。

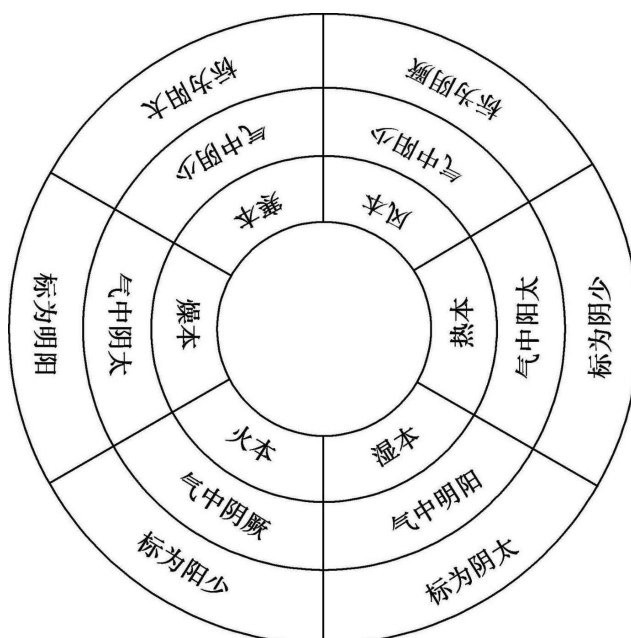


图1 上中下标本中见图

应当为之指出的是，《内经》的阴阳气化学说，是古人观察自然界气候知识的说理工具，由于人与天地相应的关系，而有“物生其应，气

脉其应”的说法，故可引用气化学说以指导六经标本中见的理论和规律。六经的标本中见方法是（以太阳为例）：足太阳经脉在外而为标，足太阳腑在里而为本，然太阳又与少阴为表里（膀胱与肾经脉互通），故太阳膀胱以少阴肾为中气。余经以此类推，而不加繁引（图2）。



图2 脏腑经络应天本标中气图

六经分阴阳，阴阳为标；六经分六气，六气为本。标本之间所维系的阴阳表里关系，则叫中气。“中气”在六经标本气化中有重要的意义，它能使阴阳配偶，以调节气化的盛衰，则使生机不息，而起到枢机的作用。为此，我认为，标、本、中的关系并非是孤立的，而是一个互相联系的有机体，它们在气化过程中，皆负担一定的气化职责。所以，我们对《至真要大论》说的“少阳太阴从本，少阴太阳从标从本，阳明厥阴不从标本，从乎中见”的提法，就不必要生搬硬套而死于句下。我又认为古人所说的“从”，乃是相对之言，而非绝对之论。然注家多不能识其理趣，不敢逾越一步，就束缚了它们的作用。比如说少阳本火而标阳，太阴本湿而标阴，标本之气同性，故在运用时，古人或从少阳火气之本，或从太阴湿气之本，这种以本带标方法，去反映少阳、太阴的病理变化，肯定说是对的。但在从本的同时，古人并非置“中气”于不顾，如果少阳和太阴没有“中气”的环节，则阴阳失偶，使从本之理就不能做到深透和详尽。所以，我们讲求六经标、本、中气化学说时，首先要建立三者之间的有机联系。为了说明问题，现结合六经病标本中见气化学说分述如下：

一、太阳经病

太阳为寒水之经，本寒而标热，中见少阴之热化。由于太阳标本气异，故有从本和从标之说。然而寒水虽为太阳之本，但它能产生标阳之热，因为太阳“中气”是少阴。少阴之气为热，这个热把太阳寒水温化而为气时，则外出于太阳，达于体表，布濩周身，而起到固表御邪的标阳作用。可以看出，“气”是从水生，“水”则由气化，两者缺一不可，亦见太阳藉赖“中气”的气化作用。此外，太阳病中也出现较多的少阴寒证，这并非偶然之事，而和“中气”的气化不及有密切关系，故不可漠然置之，而不加研究。

基于上述，则对太阳的标、本、中应当俱从而为全，不得只限于从标本之一格。如外邪初客于表时，出现的恶寒之证，可理解为从本气之寒；出现发热之证，可理解为从标气之热。若太阳经标之病及于本腑，经标有病则脉浮、发热；本腑有病则口渴而小便不利，治用五苓散是发汗以利小便之法。若太阳本腑之病及于经标，本腑有病则小便不利，心下满微痛；经标有病则头项强痛，无汗而翕翕发热，治用桂枝去桂加茯苓白术汤，是利小便以解外之法。唐容川对这两条体会颇深，他说：“五苓散重桂枝以发汗，发汗即所以利水也；此方（指桂枝去桂加茯苓白术汤）重苓术以利水，利水即所以发汗也。实知水能化气，气能行水之故，所以左宜右宜。”

唐氏所说的“气”，而有标阳的涵义；所说的“水”而有本寒的涵义，他既揭示了太阳标本之间发病的关系，又道出了“中气”在发病中的作用，其见解极为清新。

二、阳明经病

阳明本燥而标阳，中见太阴之湿化。古人认为阳明不从标本，而从太阴中见之化。因为两阳合明，名曰阳明，则阳气充盛，亦可见矣。故必制之以阴，方使气和而无病，为此，应中见太阴而使平。又阳明恶燥而喜湿，燥得湿则相济为美；若湿太盛，或燥太盛，则不得其平而为病。为此，如果阳明之“中气”不及，则不从中化而从本气之燥化，抑或从标阳之热化，于是则燥热亢盛，而成阳明胃家实证，或阳明热盛之证。由此来看，阳明燥则从本，热则从标，然无不与“中气”之湿不及有

关。古人让我们从湿的对立面，去认识燥热的问题，这就叫一分为二的辩证法思想。另外，也应看到在阳明病中也有湿的各种病变，张隐庵说：“阳明发热而渴，大便燥结，此阳明之病阳也。如胃中虚冷，水谷不利，食谷欲呕，脉迟恶寒，此阳明感中见阴湿之化也。”张氏虽言寒湿，而湿热诸证自在言外。所以，阳明从“中气”之化的学说，其理甚精。

三、少阳经病

少阳本火而标阳，中见厥阴风木。因其标本同气，故少阳从本气之火以概其标。然少阳为始生之阳，初出于地上，其气尚弱，必须藉中见之风阳而鼓动发扬，使少阳之气生升而未艾。然少阳有口苦、咽干、目眩之证，则从本气火化理固然矣；而“中气”风木之病也自在火中。请看少阳病的头目眩晕一证，非风木之化而何？不独此也，两经在发病中，其证候亦颇近似，如少阳病的咽干，与厥阴病的消渴；少阳病的心烦，与厥阴病的心中疼热；少阳病的默默不欲饮食，与厥阴病的饥不欲食；少阳病的喜呕，与厥阴病的吐衄；少阳病的往来寒热，与厥阴病的厥热胜复，两经在证候上都有貌似神合之象。由此观之，少阳不但从本，亦未尝不从中气之化。

四、太阴经病

太阴本湿而标阴，中见阳明燥化。因其标本气同不悖，故太阴从本以概标。夫太阴从本气之寒湿为病，则寒湿乱于中焦，清浊升降失判，则见腹中胀满，呕吐下利，饮食不下，时腹自痛的证候。然而，从辩证法看，太阴寒湿之盛，亦必是中见阳明燥化之不及，阳不胜阴，故寒湿得以留而为病。可见此证与“中气”之盛衰有关，亦不可不知。

五、少阴经病

少阴本热而标阴，中见太阳寒气之化。因其标本之气迥异，故少阴

应本标两从。若反映于少阴为病，则有寒化、热化两类。寒证则见手足厥冷，下利清谷，但欲寐等证。热证则见心烦不得卧，下利咽痛等证。

少阴除从标本以外，也与中见太阳有关。如少阴之邪化热而外出太阳时，可见一身手足尽热，以热在膀胱必便血；若少阴之寒搏及太阳时，则可见小便不利而少腹作痛。况少阴以寒证为多见，因兼中气之寒化也。所以，少阴不但有从标本之寒热，亦有从“中气”之寒热也。

六、厥阴经病

厥阴本气为风，标气为阴，中见少阳火气。古人认为厥阴不从标本而从中气。因为两阴交尽，名曰厥阴。阴气到此极尽，则阴极阳生，而从“中见少阳”之化。由阴变阳，以使阴阳相续，而不致绝灭。为此，厥阴为病，正处于阴阳转化的变革阶段。所以，它的证候特点以消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐衄，下之利不止为主，反映了厥阴病的寒热错杂，阴阳相干，肝胃不和等病证。

由于阴阳胜复的斗争，故可出现厥与热往来，以及或多或少的情况，说明了在阴阳的变革中，正邪相争的具体反映。为此，可以体现厥阴从中见少阳之化的理由，以尽阴阳对立统一、转化与变革的规律。

七、小结

总之，以上通过六经为病的标本中见气化学说，以反映六经六气阴阳气化之机，充分体现了气化学说是伤寒学中一门湛深的理论。但是，对它的研究和运用还很不够，还没能引起学者们足够的重视。还有的人竟视为糟粕和玄学而加以否定，使初学之人受其影响而目之为荒诞之论，以致大法微言，不能发扬光大而引以为憾！

标本中的气化学说，有辩证法思想和唯物论的观点。它能系统地分析六经的生理病理以及发病之规律，而指导于临床，为历代医家所重视，这是不无原因的。惜乎！一些伤寒注家囿于《内经》的从本、从标、从中见之言，机械地以公式照搬，而去求气化的系统性，这显然是不可能的事。为此，不揣浅陋，提出标、本、中的整体观，又对“中气”在使用中的重要意义进行了阐述，以求得同道们的批评指正。

第五讲 试论桂枝汤的加减证治

一、桂枝汤的适应证

桂枝汤是治疗太阳中风的主方。太阳中风，是指风邪外袭以后，在太阳病的提纲脉证上，又出现发热、汗出、恶风、脉缓等脉证的就叫做太阳中风证。所以，它和近代医学“脑血管意外”的中风不同。风为阳邪，犯表袭卫，卫阳与风邪相搏，故先见发热。并且发热的出现既迅速而又突出，它与以恶寒为突出临床表现的太阳伤寒证有所不同。卫阳被风邪所伤，失去了卫护肌表、管理汗孔开阖的作用，再加上风邪的不断疏泄，迫使营阴不能内守，因而可出现“自汗出”的证候。但是中风的汗出，并不是汗多而连绵不断，而仅是皮肤潮润，以手扪之可知有汗为辨。汗出则更使肌腠疏松不固，卫气随之也泄，反映在脉象上即是缓脉。张仲景在第12条对此证作了很形象的描述和很好的说明：脉“阳浮而阴弱”，即指浮取有余，重按不足的浮而缓弱的脉象。“翕翕发热”、“淅淅恶风”、“啬啬恶寒”，形容像多着衣服那样的发热，像冷水淋在身上的怕风，而怕冷又表现出一种畏缩的样子。同时由于风邪外袭，影响了肺气的宣发和胃气的下降，肺气不利则鼻鸣，胃气上逆则干呕。太阳中风的病理，可概括为“荣弱卫强”四字。“荣弱”是说荣阴失去卫阳的固护而外泄，反映了正气有不足的一面；“卫强”指风邪犯于卫分，反映了邪气盛实的一面。总的来看，风邪外袭以致荣卫不和，就是太阳中风证最基本的病理特点。

太阳病的中风证当用桂枝汤治疗，但桂枝汤却不仅限于治太阳中风证。如本属太阳伤寒证，经过汗下之后，表邪仍不解，或虽经汗解，但又复感风寒，病在表者，均可以用桂枝汤再行解表。为什么不用麻黄汤呢？这是因为病虽原属伤寒，但已经汗下，尽管表证仍在，也不宜再用峻汗之法。用桂枝汤可解肌发表，调和荣卫，虽发汗祛邪，但又不损伤正气。正如第57条说：“伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤”。还有一种情况，即有的病人内脏并没有反映什么毛病，只是不时的自汗出，或伴以发热，这是什么原因呢？这是因为“卫

气不和”，“卫气不共荣气谐和故尔”。也就是说，虽然病人营气和顺，但卫气不和，不能与营气密切协作，以致营卫各行其是，卫气不能外固，营阴不能内守，因而“常自汗出”，或“时发热自汗出而不愈”。这种既非太阳中风，又“脏无他病”的荣卫不和证，也要用桂枝汤，在发病之前服药取汗，使营卫调和则愈。

桂枝汤由桂枝、芍药、炙甘草、大枣、生姜组成。方中桂枝温通卫阳，配生姜之辛，以解卫分之风邪；芍药味微苦酸，能敛阴和营，配大枣之甘，可滋养营阴之弱；甘草和中扶虚，佐桂、芍以和阴阳。以上五药，内含辛、酸、甘等味，由于辛甘化阳可以助卫；酸甘化阴可以和营，故桂枝汤有调和营卫的功效。本方服法，要求药后喝热稀粥，温覆避风，其目的是使谷气内充，既可以助桂枝发汗驱除卫分之邪，又可以内资汗源而和营阴之虚。

柯琴在评价桂枝汤时说：“此为仲景群方之魁，乃滋阴和阳，调和营卫，解肌发汗之总方也。凡头痛发热，恶风恶寒，其脉浮而弱，汗自出者，不拘何经，不论中风、伤寒、杂病，咸得用此发汗；若妄汗、妄下，而表不解者，仍当用此解肌。如所云头痛、发热、恶寒、恶风、鼻鸣、干呕等病，但见一证便是，不必悉具，惟以脉弱自汗为主耳”。

桂枝汤有双向调节的作用。它能发汗以止汗，发汗而不伤正，止汗而不留邪。在外它有调和营卫之功，在内则有调和气血之用。它的特点是以调和中焦脾胃阴阳为主，故可以调节气血、营卫等的不和。观方中五药，如生姜、大枣、甘草，皆为厨中调料之品，而有健脾开胃之功；且桂枝芳香而味窜，能促进食欲，又有通阳、理气之效。此方乃古《汤液经》之绪余，抑为伊尹之手制欤？

在《伤寒论》113方中，有桂枝的计41方，以桂枝进行加减的则不下29方。所以在临床中，桂枝汤的应用机会较多。为此，我们不但应从理论上进行探讨，还必须结合实践加以印证。现将临床有关治疗医案附载于下，以供使用桂枝汤时参考。

二、桂枝汤的临床应用

（一）治疗时发热自汗出

李某，女，53岁。每天都有两、三次发热汗出之证阵阵发作。病程

一年，饮食、二便尚可。曾按阴虚发热治疗，服药20余剂无效。切其脉缓软，视其舌淡苔白，遂辨为营卫不和之证。夫营卫者，阴与阳也。营卫谐和，则营阴来济卫阳，而热则不发；卫阳来护营阴，而汗则不出。今营卫不和，各行其是，两者不相将，故时发热而自汗出。

治当调和营卫，和其阴阳，使营卫相依则病愈。为疏桂枝汤方，服后取微汗而瘳。

20年前，我携中医系同学在京西矿区进行临床实习期间，偶感风寒而患病，症见发热，并在发热时伴有周身出汗，于是自觉烦郁而思凉，然一揭开衣被，则又啬淅畏恶风寒。鼻流清涕，涓涓不止，周身不适，时或干呕，切脉为浮缓。余自知为太阳病之中风证，用桂枝汤原方，如法啜粥取汗而愈。此后，方对《伤寒论》第2条的“太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓”的叙证次第，有了新的认识和体会。

（二）治疗荨麻疹

一男性患者，60岁。患荨麻疹，瘙痒钻心难耐，数月不愈。切其脉浮而缓，并见汗出恶风之证，视其舌苔则白润。

辨证：证属风邪稽留肌肤，营卫失和之“风疹”为患。

治法：祛风，调和荣卫。

处方：桂枝汤。

药后啜粥取汗，则痒止疹消，脱皮屑盈掬。

（三）治疗汗出偏沮

孙某，男，39岁。患左半身经常出汗，而右半身则反无汗，界限分明。脉缓而略浮，舌苔薄白。

辨证：《素问·阴阳应象大论》曰：“左右者，阴阳之道路也”。此证脉浮而缓，为虚风在经，荣卫不调，左右气血不和，以致阴阳乖戾而为病。

治法：解肌发汗，调和阴阳，调谐气血。

处方：桂枝汤。

服后啜粥取微汗，从此其病获愈。

三、桂枝汤的加减应用

桂枝汤的加减应用，仅从《伤寒论》记载看，可分加味桂枝汤、减味桂枝汤和加减桂枝汤三类，兹分述如下：

（一）加味桂枝汤

1. 桂枝加桂汤

本方由桂枝汤重用桂枝而成。治疗火劫迫汗，针处被寒，核起而赤，必发奔豚，气从少腹上冲于心等证。

崔某，女，50岁。患病颇奇，自觉有一股气从内踝沿阴股上窜，行至小腹则胀，抵心胸则气短心悸，头出冷汗，少顷气下行，则诸证随减，每日发作两三次，甚为恐怖。其人面色青黄不泽，舌质淡嫩，苔白而润，脉弦数，按之无力。

辨证：此证中医名“奔豚”，然如此证者实属罕见。且奔豚发作，皆因心阳虚于上，坐镇无权，下焦肾之阴邪得以上冲。今阴来搏阳而与之争，故脉虽弦数而按之无力。况弦脉属阴，阴气上逆是以脉弦。当奔豚气所过之处，则发胀、憋气、心悸等证相继出现，亦勿怪其然。舌质淡嫩，则是心阳之虚。

治法：助心阳，伐阴降冲。

处方：桂枝加桂汤，另服黑锡丹6克。

共服五剂，其病即止，不再发作。

2. 桂枝加芍药汤

本方由桂枝汤倍用芍药而成。在《伤寒论》第279条治：“太阳病下之后，腹满时痛”之证。余取其义，用治慢性菌痢有效，录其案如下：

王某，男，46岁。病见每日大便作痢，达3~6次，不成形，且有红

色黏液，兼有里急后重。其脉沉弦而滑，舌质红而苔白。西医诊为慢性菌痢，粪检有红、白细胞。病程延续一年而治疗无效。

辨证：肝脾不调，气血不和，肝木乘脾，脾失运化，则阴阳不得升降，是以腹痛下利而脉弦。此证非寒非热，介于虚实之间，故补之无功，而寒热之治亦无效。

治法：平肝和脾，调其气血，则虽不治痢而痢亦可止。

处方：？桂枝加芍药汤。

共进四剂，大便即逐渐成形而愈。

若本方加大黄，叫桂枝加芍药大黄汤（亦名桂枝加大黄汤），治腹满疼痛，或下利脓血，后重难通等证，而脉弦有力，口不渴者，服之有效。

3.桂枝加葛根汤

本方由桂枝汤加葛根而成。治中风汗出恶风，反见项背强^{几几}等证，它有祛风通经和滋润经脉的作用。临床治疗冠心病的胸背作痛，高血压动脉硬化的后脑部疼痛，用之得当均有疗效。

张某，女，26岁。因乘长途汽车，面朝敞窗，疾风拂面，当时殊觉凉爽。抵家后发觉面肌拘紧，口眼^喎斜。切脉浮，舌苔白而润。

辨证：风中阳明经络。正如《金匱要略》所说：“络脉空虚，贼邪不泻，或左或右，邪气反缓，正气即急，正气引邪，^喎僻不遂”之证。

治法：祛阳明经络之风邪。

处方：桂枝加葛根汤，另加白附子、全蝎。

服两剂，汗出邪解，其病遂愈。

4.桂枝加人参汤（简称新加汤）

本方由桂枝汤加重芍药、生姜用量，再加人参而成。治疗发汗后身疼痛，脉反沉迟等证。余在临床治妇女产后，或行经后，因失血营虚不能充养肢体出现的身体疼痛，脉迟涩无力等证，用此方往往获效。

樊某，女。新产之后忽而身痛，服生化汤无效。随我学习的学员诊为气血两虚的身痛，用十全大补汤亦有效而功不捷。切其脉沉缓无力，

视其舌则质淡、苔薄白。嘱改用桂枝汤加人参，三剂而痛止。学员不解其意，余曰：疗效在于方中的桂枝、生姜能使人参、芍药补气血的作用达于体表，它补而不滞，又可使营卫功能加强，所以疗效为著。

5.桂枝加附子汤

本方即由桂枝汤加附子而成。治疗发汗后，汗漏不止，恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸等证，有固阳摄阴止汗等作用。余认为对老年人阳虚感寒，脉沉而汗出恶风的，用本方加大附子剂量，以温经扶阳，实为正邪兼顾之计。它与麻黄附子细辛汤证的区别，则是在于汗之有无。如服桂枝加附子汤不瘥，则当急固其本，用四逆汤。

6.桂枝加黄芪汤

本方由桂枝汤加黄芪而成。仲景用其治疗黄疸病脉浮，日久卫虚之证。意在言外，还当具有发热、汗出的证候在内。然此方在临床上治疗末梢神经炎、手足麻木等证也有疗效。

7.桂枝加栝蒌根汤

即桂枝汤加栝蒌根而成。治疗由于津液不足，太阳经脉燥急所发生的痉证。症见：身体强，**几几**然，脉沉迟者。它与葛根汤对比，有脉浮与脉沉，口渴与不渴之别。

8.桂枝加厚朴杏子汤

本方由桂枝汤加厚朴、杏子而成。治疗太阳病中风证兼见气喘，临床凡见气喘因外感风寒，脉浮而缓，舌苔白者，均可施用。此证之喘若与麻杏甘石汤证相比，则有寒热之异，若与麻黄汤证相较，则有虚实之别。

（二）减味桂枝汤

桂枝去芍药汤 本方治疗太阳病，下之后脉促，胸满之证。临床用于心脏病伴发胸满、短气、咳嗽等证，也同样有效。

（三）有加有减桂枝汤（即加减桂枝汤）

1.桂枝去桂加茯苓白术汤

本方治疗服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利之证。余用此方治疗“水悸”与“水痞”，腹诊时有腹肌痉挛的有效。昔陈修园于嘉庆戊辰，治吏部谢芝田令亲之头项强痛，身疼，心下满，小便不利，服表药无汗反烦，六脉洪数。初诊疑为太阳阳明合病，谛思良久，曰：前病在无形之太阳，今病在有形之太阳。但使有形之太阳小便得利，则所有病气，俱随无形之经气而汗解矣。用桂枝去桂加茯苓白术汤遂瘳。

2.桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤

本方治火劫迫汗，心胸阳虚，促使痰水之邪上迷心窍，发为惊狂卧起不安等证。余师其说，用治精神分裂症，舌淡苔润的，试之有效。服药后，有的病人有作吐的反映，亦不可不知。

3.桂枝去芍药加附子汤

此方治疗太阳病，下之后脉促胸满，而又有阳虚恶寒等证。余宗其义，治疗心胸阳虚，寒邪凝滞的胸痹，亦有疗效，今录治案如下：

王某，男，46岁，建筑工人。多年来胸中发满，甚或疼痛，遇寒冷气候则甚，并伴有咳嗽气短等证。切其脉沉弦而缓，握其手则凉，询其小溲则清长，视其舌质淡嫩，苔白略滑。

辨证：心阳不振，阴霾布于胸中，气血为之不利，然亦胸痹之证类也。

治法：温补心阳，以解寒凝。

处方：桂枝去芍药加附子汤。

连服六剂，证情逐渐减轻，多年胸中闷痛，从此得以解除。

综上所述，可见桂枝汤能解肌发汗，又能调和气血营卫、脾胃阴阳，以及下气降冲，扩张血脉，缓解痉挛，故其加减之法不胜枚举，仅列以上数例，以资参考而已。

第六讲 试论麻黄汤的加减证治

一、麻黄汤的适应证

麻黄汤是治疗太阳伤寒的主方。太阳伤寒，是指寒邪外袭以后，在太阳病提纲证上，又出现身疼，腰痛，骨节疼痛，恶寒，发热，无汗而喘等证的就叫做太阳伤寒证。所以它和近代医学的“肠伤寒”不同。寒邪，在六淫邪气中属于阴邪，侵犯人体，最易损伤阳气。人体阳气被寒邪所伤，失去正常的温煦作用，所以必见恶寒。太阳伤寒的恶寒，是很严重的，即使多穿衣，多盖被，或者烤火取暖，也常常是不得缓解。寒主凝滞、主痛、又主收引，故除恶寒之外，还见各种疼痛之证。外感寒邪，营卫凝涩不利，皮毛腠理敛缩闭塞，所以身上不出汗，即扪其皮肤灼热烫手，但无丝毫汗意可言，这在诊断上很有价值。“肺之合皮也，其荣毛也”，皮毛汗孔被寒邪闭郁，肺气也就不得宣发，肺气失宣，则气逆作喘；若影响到胃气的和降，还可见到呕逆。此证无汗而表实，且为寒邪所伤，使脉紧而有力，故脉浮紧而异于中风之浮缓。桂枝证与麻黄证均属太阳病，故脉浮，头项强痛，而恶风寒是它们的共见证。但桂枝证为表虚，以汗出、恶风、脉浮缓为主；麻黄证为表实，以无汗、恶寒、身疼、脉浮紧为主，两者有所不同，不可混淆。

麻黄汤由麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草四味药组成。麻黄辛温，可发散风寒，开腠理而发汗，宣肺平喘；桂枝通阳解肌，助麻黄发散风寒；杏仁苦温润肺，助麻黄宣肺平喘；甘草则调和诸药而护正。本方为辛温发汗之峻剂，但麻黄与甘草的剂量之比，以三比一为准，如此服之方能奏发汗之效。

二、麻黄汤的临床应用

麻黄汤不仅是发汗解表药，而且也是治喘的圣药。全世界的医生都知道麻黄能治喘，但它们却不知道第一个提出麻黄治喘的是我国后汉时

期的张仲景，这也说明了中医药学确是一个伟大的宝库。麻黄汤除发汗平喘之外，还治“痹痛”以及各种寒性疼痛之证，所以，后世凡治痹证疼痛都离不开麻黄就可以想见了。本方对后世的影响很大，现仍有实用价值，不得忽视。

我于1967年随医疗队去甘肃省，时值隆冬季节，因冒受风寒而患“伤寒”证，周身关节无处不痛，恶寒特甚，体温39.8℃，无汗，咳嗽，脉浮紧。我自己开了一张麻黄汤方，服药后躺在火炕上发汗，约一时许，通身汗出而愈。

据医案记载，本方还有催生的作用，这是因为在冬季寒冷之时，产妇受寒，气血收缩而致分娩困难。若投以麻黄汤则寒散气和，血脉流通，而达到治疗目的。

三、麻黄汤的加减应用

麻黄汤的加减应用，为治疗伤寒各种兼证而设，如推而广之，也可治疗各种杂病。如以伤寒兼证而言：其中包括伤寒挟水饮咳喘的小青龙汤证；兼阳郁不伸而烦躁的大青龙汤证；以及兼太阳经输不利的葛根汤证。如以杂病而言：小青龙汤则能治支饮，大青龙汤则能治溢饮，而葛根汤又能治“刚痉”等证。

（一）小青龙汤

本方治疗伤寒又兼夹水饮之证。《伤寒论》把它的病机概括为“伤寒表不解，心下有水气”。“伤寒表不解”，是说有恶寒、发热、无汗、身疼、腰痛等太阳伤寒表证存在；“心下有水气”，是指素有水饮内停犯胃，胃气不降则上逆作呕；外寒内饮，上射于肺，肺失宣降则咳喘。由于水邪变动不居，可随气机升降到处为患，故可见水寒停于下的小便不利，少腹满；水寒壅滞于上，阻碍气机的噎；水饮内停，气不化津的口渴等或见之证。因属寒饮为病，所以脉弦，苔白而润滑。如从痰上辨证：多咳吐清稀泡沫样痰，落地成水，或痰寒而亮，如鸡蛋清状，这些脉证对本证的辨别有重要意义。治用小青龙汤，外解风寒，内散水饮。

小青龙汤由麻黄、桂枝、芍药、细辛、干姜、半夏、炙甘草、五味

子组成。方中用麻黄发散风寒，平喘利水；配桂枝，可增强通阳宣散的功能；干姜、细辛能散寒化饮；半夏去痰降逆；炙甘草扶正和中；恐辛散太过，反耗伤正气，故用五味子酸收，以保肺肾之气；又以芍药酸苦微寒，敛营阴而防动血。如此配伍，可使邪去而正气不伤。

本方在临床上并不限于治疗表寒内饮证，即使没有表证，但只要属于寒饮咳喘，就可加以使用。若寒饮有化热趋势的表现，如见烦躁而喘的，可在方中加生石膏。只要辨证准确，临床使用本方多可收效。但因它不仅能发散阳气，而又能伤阴动血，虽有五味子、芍药之护正，仍不宜久服，对某些心脏病、肺结核的咳喘，更应慎用。

记得有一次带同学在门诊实习，治一男性患者，咳喘痰多而不能平卧。视其面色黧黑，舌苔白滑，脉则弦劲，吐稀白泡沫痰。辨为寒饮射肺之证。时值冬季，气候凛冽，为疏小青龙汤原方两剂，患者去后不复来诊。次年春，患者又来门诊，请余诊病。视其面色天然不泽，身体殊羸弱，乃问其故。患者曰：去年冬服药见效，已能夜间平卧，痰喘俱减，喜不自胜，自照原方继服十余剂，遂发生头晕、心悸、夜不成寐等证。冬至节后，忽而发生鼻衄，来势汹涌，不能自止，于同仁医院电烙止血。然失血太多，疲劳为甚，故又来诊治。余曰：前服之药为小青龙汤，虽能散寒饮，亦能动阳气。久服之后，下伐根本，而使少阴精气不藏，故伤阴动血，则已势所必然。乃用人参养荣汤加龙骨、牡蛎等药，服数十剂，体力方渐渐恢复。

（二）大青龙汤

本方治当汗不汗，表邪郁遏不解，以致阳郁化热，而形成“不汗出而烦躁”的表寒兼内热的证候。表寒不解，所以脉浮紧、发热恶寒、身体疼痛等证俱在。当汗不汗，卫阳被遏而化热，阳热内扰，故见烦躁。这里的表寒与内热，虽是两种不同的病理变化，但二者之间有着密切的内在联系。《伤寒论》中所说的“不汗出而烦躁”，就指出了烦躁是由于不得汗出，阳郁不宣所致。单是表寒不解，只用麻黄汤发汗就可以了。本证是外寒兼内热，所以麻黄汤已不适用，而当用大青龙汤外解风寒，内清烦热。

大青龙汤是由麻黄汤倍用麻黄，再加生姜、大枣、生石膏而成，因此可以说是麻黄汤的加味方。方中重用麻黄，助以桂枝、生姜发汗以解表；用杏仁利肺气，助麻黄之宣发；生石膏辛甘大寒，配麻黄解肌以开

阳气之郁闭，并能清热除烦；甘草、大枣能和中扶正，在发汗剂中还有资助汗源的作用。

大青龙汤属发汗峻剂，体质壮实者可用，体质虚弱者则不可用。如病人脉微弱，汗出恶风，属于中风表虚的，也不能用。如果误用，可因发汗太多，以致发生四肢厥逆，肌肉跳动的亡阳之变。为防止汗多亡阳，张仲景特别在方后注中说：“汗出多者，温粉扑之。一服汗者，停后服”。“温粉”即米粉炒温，扑在身上用以止汗。

有一位姓邱的医生，在我院旁听《伤寒论》课，当讲到大青龙汤证时，他介绍了用本方的一例验案：他家乡一壮年社员，在抗旱打井时，于遍身汗出如洗的情况下，缒绳下井。井底则寒气逼人，顿时汗消，随之即病。症见：发热，恶寒，一身疼痛，烦躁难耐等。邱认为属大青龙汤证，但考虑时值暑夏，又不敢贸然进药。后在其他医生的鼓励与协助下，他给病人开了一张大青龙汤方。仅服一煎，病人即遍身汗出，热退身凉而神安。

某女，32岁，北京人。患手肿臂疼之证，经久不愈，颇以为苦。来诊时抬手诊脉亦觉吃力。经各种治疗，皆无效。脉浮弦劲，舌质红而苔水滑，二便饮食均可，经水亦调。问其病因，自述天冷洗衣，水凉而手寒，洗几次后，便觉臂疼手肿，酸楚不支。

辨证：水寒之邪，郁遏阳气，不得宣泄，因而气滞水结，与“溢饮”之证相符。因其舌红而绛，身体又壮，故可发汗清热以祛饮。

处方：大青龙汤原方。

服一剂，即汗出而安。

本方可解表滋液，疏通经脉，用于治疗太阳被寒邪所伤，经脉不利，而见“项背强**几几**无汗恶风”等证。

（三）葛根汤证

葛根汤由葛根、麻黄、桂枝、生姜、芍药、炙甘草、大枣组成。方用葛根，既能解肌表之邪，又能升津液，濡养筋脉，以缓项背之拘急；麻黄、桂枝、生姜辛温散寒，可发汗解表；芍药佐葛根，可利血脉以缓筋急；甘草、大枣和营卫而守中，也可制约麻、桂之过散。此方服后，往往出现后背发热，继之而背上汗出，次遍及全身，而项背之强急即

愈。

太阳病为邪在表，在表者当汗而发之，故以有汗为表虚，治用桂枝汤类，无汗为表实，治用麻黄汤类。虽未尽汗法之全，庶可以一隅而反三。

第七讲 试论苓桂剂的加减证治

苓桂剂，指《伤寒论》中以茯苓、桂枝为主药的方剂，其中包括苓桂术甘汤、苓桂姜甘汤、五苓散等方剂在内。为使本讲内容更为完备，也将《金匱要略》中的苓桂剂和自制之方补充了进去。苓桂剂主要是用来治疗水气上冲证的，此病为常见病和多发病，历代医家都比较重视，在临床治疗上也有所发展。水气上冲证，散见于《伤寒论》与《金匱要略方论》，张仲景提出了以苓桂为主药的一类方剂的相应治法。但文中的苓桂诸方证，分列于不同的疾病篇章，缺乏系统归纳和有机联系，使人难以掌握全面。为此，综合各条有关方证，结合个人临床体会，将苓桂剂在临床中的加减运用加以论述，以治疗包括太阳病腑证在内的各种有关水气的疾患。

一、水气的概念

古人对水气的概念，认识也颇不一致，有人认为水气是水之寒气，如成无己注水气上冲时说：“水寒相搏，肺寒气逆”；也有认为水气即水饮，如钱天来注：“水气，水饮之属也”。我认为上述两种不同的见解，似乎各自说对了一半，因为水与寒、水与饮，往往协同发病，水指其形，寒指其气，饮则指其邪，二者相因，故不能加以分割。

水气的概念，应是既有水饮，又有寒气，这样去理解，则比较恰当。

二、水气上冲的证机

水气上冲的证机是和心、脾、肾的阳气虚衰有关，而心阳虚衰又为发病的关键。

心属火，为阳中之阳脏，上居于胸，能行阳令而制阴于下。若心阳不足，坐镇无权，不能降伏下阴，则使寒水上泛，而发为水气上冲。同时，脾气之虚，不能制水于下，水无所制，也易上冲而为患。另外，肾主水而有主宰水气的作用，如肾阳不足，气化无权，不能主水于下，则亦可导致水气上冲。由此可见，水气上冲，实与心、脾、肾三脏阳气之虚有关，其中尤以心阳虚不能降伏下阴而为前提。

水气上冲的起点有二：一是由“心下”气往上冲，一是由“脐下”气往上冲。由心下气往上冲的，多因心脾气虚；由脐下气往上冲的，多因心肾气虚之所致。至于对此证的辨认，典型的则可出现明显的气由下往上冲动的感觉，不典型的，虽不见明显的气冲之感，但从下往上依次出现的或胀、或满、或悸等等见证也十分明确，故也不难辨认为水气上冲证。

心下的水气上冲证：由于水寒之气先犯心下的胃脘部位，则胃中胀满；若再上冲于胸，因胸为心之城郭，阳气之所会，今被水寒所抑，则自觉憋闷；胸又为心肺所居之地，水寒之气犯胸，则心肺必蒙其害，若肺气受阻，则咳嗽、短气；若心阳被凌，则心悸不安；若水气再上冲于咽喉，则气结成痹，犹如“梅核气”状，自觉一物梗塞喉间，吐之不出，咽之不下；如水气再往上冲，必冒蔽清阳之气，症见头目眩晕，动则为甚。头面部的眼、耳、鼻、舌皆属清窍，藉赖清阳之气的温养，则耳聪目明，鼻闻香臭，口知滋味。今浊阴之气冒蔽清阳，清阳之气不能温养清窍，则往往出现耳聋、目障、鼻塞、口失滋味等证。因此，水气上冲每有眼、耳、鼻、喉等证出现，务须注意。

脐下的水气上冲证：由于心肾阳虚，以致水寒之气得逞，遂发为水气上冲之证。此证因水与气搏，其先驱症状必见脐下悸动，而小便不利。如不及时治疗，则气从脐下上冲咽喉，来势突然，其行甚速，凡气所过之处，或胀，或悸，或窒塞，皆历历有征，古人叫做“奔豚气”。尤以冲至咽喉，每每使人憋闷、窒息、出冷汗，而有如面临死亡的一种恐怖感出现，然少顷则气衰下行，其证也随之而减。

除上述两种水气上冲的特点以外，还可从色诊、脉诊进行诊断，这也是十分必要的。

（一）色诊

水为阴邪，上凌于心，心之华在面。今阴邪搏阳，营卫凝涩，心血

不荣，故其人面带虚浮，其色黧黑，或出现水斑（额、颊、鼻柱、口角等处，皮里肉外，出现黑斑，类似色素沉着）。昔陈修园在保定望丁攀龙“面上皮里黧黑，环口更甚，卧蚕微肿，鼻上带青……直告之曰：君有水饮之病，根挟肝气，而肆行无忌”。质之于丁，其证情果如陈氏所言。此证又因心阳先虚，舌质必见淡嫩，水从下而上，苔则水滑而主津液不化。

（二）脉诊

仲景认为，水气上冲脉当沉紧，质诸临床，紧当弦体会为是。盖弦与紧，古人有时互相借用。沉脉主水，弦脉主饮，两脉皆为阴，故可反映水寒之邪为病。

以上所述水气上冲之证，如见一证两证，而色脉相应时，便可辨为水气上冲，大可不必诸证悉备。

三、水气上冲的证治

凡水气上冲，从心以下而发的，治当温阳降冲，化饮利水，方用茯苓桂枝白术甘草汤。本方由茯苓、桂枝、白术、炙甘草四药组成。方中以茯苓、桂枝为主药，白术、甘草为配伍药。茯苓在方中有四个方面的作用：一是甘淡利水以消阴；二是宁心安神而定悸；三是行肺之制节之令而通利三焦；四是补脾固堤以防水平，故为方中主药，列于首位。桂枝在本方则有三方面的作用：一是通阳以消阴；二是下气以降冲；三是补心以制水，亦为方中主要药物，列于第二位。此方如有茯苓而无桂枝，则不能化气以行津液；如有桂枝而无茯苓，则不能利水以伐阴。所以苓桂相须相成，而缺一不可。至于白术则协茯苓补脾以利水，甘草助桂枝扶心阳以降冲。诸药配伍精当，疗效确实，故为苓桂诸剂之冠。下边的加减诸证皆从此方证演绎而来。

（一）苓桂术甘汤治验

陈某，女，52岁。大便秘结，五六日一行，坚如羊屎，伴有口干

渴，但又不能饮。自觉有气上冲，头晕，心悸，胸满。每到夜间上冲之势加甚，而头目昏眩则更甚。周身轻度浮肿，小便短少不利，面部虚浮，目下色青，舌胖质淡，舌苔水滑。

辨证：此证为心脾阳虚，水气上乘阳位，水气不化，津液不行，则大便秘结而小便不利。水气上冲，阴来搏阳，故心悸、胸满、眩晕。水邪流溢，则身面浮肿。

治法：温通阳气，伐水降冲。

处方：茯苓30克 桂枝10克 白术10克 炙甘草6克

服两剂头晕、心悸与气冲之感均减，这是水饮得以温化的反映。二诊乃于上方更加肉桂3克，助阳以消阴；泽泻12克，利水以行津。服两剂，口干止，大便自下，精神转佳，冲气又有进一步的减轻。三诊转方用苓桂术甘汤与真武汤合方：桂枝10克，茯苓24克，猪苓10克，生姜10克，附子10克，白芍10克。

服至三剂，诸证皆除，面色亦转红润，从此获愈。

（二）苓桂杏甘汤治验

苓桂杏甘汤，即于上方减白术加杏仁而成。此方治水气上冲，迫使肺气不利，不能通调水道，而见小便困难，面目浮肿以及咳喘等证。1980年我带78届研究生在门诊实习，治一老年妇女，咳嗽而微喘，面目浮肿，小便较短。曾服药不下百余剂而面肿迄未消退。切其脉弦，舌略胖，苔水滑。

辨证：水气乘肺，则咳而微喘；肺气不能通调水道，则小便不利而面肿。

治法：通阳下气，利肺消肿。

处方：茯苓12克 桂枝10克 杏仁10克 炙甘草6克

患者见方仅四味，又皆普通药物，甚疑其效。然服五剂，则小便畅利，面肿消退，咳喘皆平而愈。

（三）五苓散治验

五苓散，即苓桂术甘汤减甘草，加猪苓、泽泻而成。此方能治“渴欲饮水，水入则吐”的水逆证（为水气上冲之一），以及“脐下有悸，吐涎沫而癫眩”的癫痫证。

王某，男，18岁。自觉有一股气从小腹上冲，至胃则呕，至心胸则烦闷不堪，上至头则晕厥、不省人事。少顷，气下行则苏醒，小便少而频数。其脉沉，舌淡嫩，苔白润滑。

辨证：心脾阳虚，气不化津，发为水气上冲之证。水气上冒清阳，故有癫痫发作。脉沉主水，舌淡为心阳虚，小便不利为水气不化。故知此证为水气所致。

治法：利水下气，通阳消阴。

处方：茯苓30克 泽泻12克 猪苓 白术 桂枝各10克 肉桂3克
服三剂，病发次数见减，小便通利，继服六剂，病除。

（四）苓桂味甘汤治验

苓桂味甘汤，即苓桂术甘汤减白术、加五味子而成。此方一是治疗肾气素虚之人，因误服小青龙汤发动肾气，引发肾气不摄，气从少腹上冲于胸；甚或为上厥巅疾，头目眩冒，面赤如醉，心悸，脉结，少气而喘等证。二是治老人下虚，不主摄纳，饮从下泛，气阻升降而为喘咳之变。昔叶香岩用本方，或另加姜枣治疗此证，效果非常理想。因为他从甘温化饮，酸温纳气为治，故深得仲景治病之法。《临证指南医案》载有此案，可以作为借鉴，故不多录。

（五）苓桂姜甘汤治验

苓桂姜甘汤，原名为茯苓甘草汤，为了便于记忆，故易今名而收于苓桂剂群之内。

此方即苓桂术甘汤减白术、加生姜而成。其治疗水饮潴留于胃，迫使气与饮搏，而症见心下悸动不安。若胃中水饮上逆，则可出现“水吐”；若胃中水饮下流于肠，则可出现“水泻”；若胃中水饮阻遏清阳不达四肢，则见手足厥冷，名叫“水厥”。

农民陈某，男，26岁。因夏天抗旱，担水浇地，过劳之余，汗出甚多，口中干渴殊甚，乃俯首水桶而暴饮。当时甚快，未几发现心下悸动殊甚，以致影响睡眠。屡次就医，服药无算，然病不得除。经友人介绍，请余诊治。令其仰卧床上，以手扪其心下，则跳动应手，如是用手振颤其上腹部，则水在胃中漉漉作响，声闻于外。余曰：此振水音也，为胃中有水之征。问其小便尚利，脉弦而苔水滑。

处方：茯苓12克 桂枝10克 生姜汁一大杯 炙甘草6克

嘱用煎好药汤兑姜汁服。服后便觉热辣气味直抵于胃，而胃中响动更甚。不多时觉腹痛欲泻，登厕泻出水液甚多，因而病减。照方又服一剂，而悸不发矣。

（六）苓桂枣甘汤治验

苓桂枣甘汤证，是心阳上虚，寒水下动，待发未发，先见“脐下悸”、“欲作奔豚”，也就是水气之邪从脐下上冲的一种。于苓桂术甘汤方减白术、加大枣，并增添茯苓的剂量，用甘澜水煮药，服之则愈。此方治“奔豚”已发亦同样有效。奔豚证：为气从少腹上冲咽喉，憋闷欲死，使人精神紧张。而气冲所经之处，或胀、或悸、或窒，皆历历有征。少顷，气往下行，其证则减。

郭某，男，56岁。患奔豚气证，发作时气从少腹往上冲逆，至心胸则悸烦不安，胸满憋气，呼吸不利，头身出汗，每日发作两三次。切其脉沉弦无力，视其舌质淡而苔水滑，问其小便则称甚少，而又有排尿不尽之感。

辨证：水气下蓄，乘心脾阳虚而发为奔豚。考《伤寒论》治奔豚有两方，而小便不利者，则用本方为宜。

处方：茯苓30克 桂枝12克 大枣12枚 炙甘草6克

嘱患者以大盆贮水，以杓扬水，水面有珠子五六千颗相逐，用以煮药。

患者服两剂，小便通畅而“奔豚”不作。转方又用桂枝10克、炙甘草6克，以扶心阳，其病得愈。

以上列举六个苓桂剂加减治案，在于使人随证加减，触类旁通，以见圆机活法之妙。然余有所思焉，以今之各种心脏病，就余所诊，其中有相当一部分是属于水气上冲证者。而目前之治冠心病者，又仅守活血

化痰之一法，美则美矣，而法未尽也。如能从水气上冲证中而补其所缺，则思过半矣。

（七）苓桂杏苡汤治验*

*表示引自张仲景之后诸家医方，下同。

苓桂杏苡汤即苓桂术甘汤减白术、甘草加杏仁、苡米而成。本方治水邪上逆，兼挟湿浊，水湿相因而为病。症见：咳嗽多痰，头重如裹，胸满似塞，小便不利，周身酸楚，不欲饮食等证。

曾治一李姓患者，年已八旬开外，然身体犹健，生活尚能自理。入冬以来，即时觉胸满、气短、咳嗽吐白痰，周身酸懒，不欲行动。不喜肥甘，喜欲素食。切其脉弦缓无力，视其舌质淡而苔白腻。

辨证：心胸阳虚，阴霾用事，是以胸满而气短；水湿皆盛，化而为痰，阻于肺则咳而吐痰；滞于胃湿浊不利，故不欲食肥甘而欲素食。

治法：通阳化饮，渗利水湿。

方药：茯苓12克 桂枝10克 杏仁6克 焦苡米12克

此方服六剂，则诸证皆减。转方用五味异功散巩固疗效，以善其后。

（八）苓桂芥甘汤治验*

水为阴邪，性本就下。若发为上冲，亦有因于肝气激扬使然。清人张令韶、陈修园等人注释苓桂术甘汤证有“脾虚而肝乘之，故逆满”的说法，是有一定道理的，可供参考。据此，余在临床治疗水气上冲，而又有肝气作暖、头晕目胀，又以夜晚为甚、脉沉弦等症时，则于苓桂术甘汤减白术，又加白芥子3克，使其疏肝下气，开阴凝之邪，每收功效。

曾治一曹姓妇女，年43岁。胸胁发满，入夜为甚，头目眩晕，心悸气短，时时作暖，而易发怒。问其月事，则经来过期，而且小腹作胀。脉沉弦，舌苔水滑，面色黧青。

辨证：水气上冲，兼挟肝气，是以气血不和而暖气腹胀，月经后期也。

治法：温阳化饮，疏肝理气。

处方：茯苓12克 桂枝10克 白芥子3克 香附6克 炙甘草6克

此方续服六剂，诸症皆减，尤以暖气不作，而胸胁敞快。转方以小剂桂枝茯苓丸为汤，另加郁金、香附等解郁之药而获全绩。

（九）苓桂茜红汤治验*

苓桂茜红汤，即苓桂术甘汤减去白术、甘草，加红花、茜草而成。此方为余手制，常用于某些冠心病患者。他们既有水气上冲的证候，复有心前区疼痛控背及手指发麻等气血瘀阻的证候。此方用苓桂通阳化饮，红花、茜草活血脉而行瘀滞。根据临床观察，服后疗效颇显。例如，曾治太原曹某，自称患有冠心病。最近头晕，胸满且疼，控及后背。切其脉弦，视其舌边有瘀血斑，而苔则水滑欲滴。余辨为水气上冲，挟有血脉瘀滞，而思出此方，姑且试之。病人连服五剂，竟觉症状大减，喜出望外。从此，余又在临床用过几次，也同样的有效。并且，如遇患者血压偏高的，可加用牛膝10克，有很好的降压作用。

（十）苓桂龙牡汤治验*

苓桂龙牡汤，即苓桂术甘汤减白术，加龙骨、牡蛎而成。此方治疗水气上冲，兼见心中惊悸，睡卧不安，头晕耳噪，夜不成寐等症。

陆某，男，42岁，因患冠心病住院。经治两月余，病情未解。其症为心前区疼痛、憋气，心悸，恐怖欲死。每当心痛发作，自觉有气上冲于喉，则气窒殊甚，周身出冷汗。脉弦而结，舌淡苔白。

辨证：此系心阳虚衰，坐镇无权，水气上冲，阴来搏阳，而使胸阳痹塞，则心胸作痛；水气凌心，则心悸而动；心律失调，则脉弦而结；阴霾密布，胸阳不振，故胸中憋气而喉中窒塞；水邪发动，肾阳失于约束（肾志为恐），则其人恐怖欲死。

治法：通阳下气，利水宁心。

处方：茯苓18克 桂枝10克 炙甘草6克 龙骨、牡蛎各12克

服三剂，心神得安，气逆得平，但脉仍结，并伴有明显的畏寒肢冷

的现象。转方用真武汤加桂枝、甘草而逐渐恢复，因而出院。

第八讲 试论白虎汤类的加减证治

白虎汤类，指的是白虎汤、白虎加人参汤、白虎加桂枝汤、竹叶石膏汤、白虎加苍术汤、玉女煎、化斑汤七个方剂而言。这七个方剂以白虎汤为代表，其余六方，皆是在白虎汤基础上加减变化而成的。

一、白虎汤

白虎汤是治阳明热证的主方。阳明热证，是指阳明里热炽盛，但尚未敛结成为腑实，热在阳明气分而弥漫全身，充斥内外，表现为表里俱热的一种证候。阳明热证与阳明腑实证比较，腑证可以说是有形之里实，而热证则是无形之里热。因热证之身热来自于里，并非邪在经表，故也不同于阳明经证。

阳明里热，弥漫全身，充斥内外，故一身表里皆热；热盛迫津外泄，故汗出；热盛津伤，故口渴舌干，烦渴而喜冷饮；阳明热甚，气血沸腾，故脉洪大或浮滑而数。以上所述大热、大汗、大渴、脉洪大，即“四大证”，可以说是阳明热证的典型证候，也是阳明热证的辨证要点，其中尤以烦渴和汗出而为使用本方主要之根据。

白虎汤由石膏、知母、甘草（炙）、粳米四味药组成。方中石膏大寒，善清阳明气分之热而不伤津；知母苦寒而润，既能清热，又能资助肺胃之阴；粳米、甘草滋养胃腑气液，以免中寒之弊。四药合用，共奏清热生津之功。

孙某，女，3岁。出麻疹后，高热不退，周身出汗，其汗出情况，即一身未了，而又出一身，随拭随出，可以目见。因思仲景所说“濇濇汗出”，证何其似也。患儿口渴唇焦，饮水不辍，切其脉滑数，视其舌则见薄黄。

辨证：此为阳明气分热证，迫津外渗所致。治当清热生津，以防痉厥之变。

处方：生石膏30克 知母6克 甘草6克 粳米一大撮

服一剂，即热退身凉，汗止而愈。

郑某，男，22岁。外感时邪，高热神糊，手足厥冷如冰，且时时索水喝，睡则呓语频作。切其脉洪大任按，视其舌质绛而苔黄，问其二便，尚皆通顺，唯小便则色黄。

辨证：此为阳明“热厥”之证，热邪有内闭之危。治当辛寒重剂，以清阳明之热，佐以芳开，以杜邪传厥阴心包之路。

处方：生石膏30克 知母9克 甘草6克 粳米一大撮 广犀角3克 菖蒲3克 连翘心3克 郁金3克

此方共服两剂，则热退厥回，病愈而安。

二、白虎加人参汤

白虎加人参汤是治疗阳明表里俱热，表现为口干舌燥、烦渴特甚，以致“欲饮水数升”的同时，还更见“时时恶风”、“背微恶寒”，或大渴而脉按之则芤。这说明大热所及，不仅伤津，而且耗气。阴津大伤，无液以滋，故口干舌燥、烦渴不解；元气受损，无以卫外，故时时恶风，背微恶寒；热盛而气阴不足，故脉大而芤。此时若单用白虎汤清热，显然不足胜任，应加人参以益气生津，正邪两顾为妥。

李某，男，52岁。患糖尿病，口渴多饮，饮后复渴，似有水不解渴之感。尿糖阳性、血糖超出正常范围。其人渴而能饮，但饮食并不为多，大便亦不秘结。问其小便则黄赤而利，然同饮入之水量比则少。脉来软大，舌红无苔。

辨证：此为肺胃热盛，气阴两伤之证，此病当属“上消”。治当清上、中之热而益气阴之虚为宜。

处方：生石膏40克 知母10克 甘草6克 粳米一大撮 人参10克 天花粉10克

此方共服五剂，则口渴大减，体力与精神均有好转。化验血糖与尿糖，程度减轻。转方用：沙参12克，玉竹12克，麦冬30克，花粉10克，太子参15克，甘草6克，知母6克。

此方服十数剂，病情明显好转，后以丸药巩固疗效。

林某，女，38岁。夏日午睡后，昏不知人，身热肢厥，汗多，气粗如喘，不声不语，牙关紧急。舌苔黄燥，脉象洪大而芤。

辨证：病属暑厥。暑为大热之邪，燔灼阳明，故见身热炽盛；暑热内蒸，迫津外泄，则多汗而气粗如喘；热郁气机，所以四肢反见厥冷；邪热内迫，扰于心神，正又不能胜邪，故神昏不语，脉见洪大而芤。治以清暑泄热，益气生津。

处方：白虎加人参汤。

朝鲜白参 知母 粳米各15克 石膏30克 甘草9克

服一剂后，脉静汗止，手足转温，神识清爽，频呼口渴，且欲冷饮。再投一剂而愈。

引自《苏伯鳌治案》

三、白虎加桂枝汤

白虎加桂枝汤出自《金匮要略方论》，用以治疗“温疟”之病。温疟为病是但热不寒，邪气内藏于肾，至春夏而发，为伏气外出之证。因为寒已化热，故不恶寒而发热；邪从肾出，外舍于其合，故骨节烦疼；时时作呕者，而邪热上并于阳明胃也；其脉如平者，因病非乍感，故脉象变化不大。

白虎加桂枝汤由知母、石膏、炙甘草、粳米、桂枝五药组成。此方以白虎汤清内伏之热；加桂枝以引领石膏、知母上行至肺，从卫分泄热，使邪之郁于表者顷刻致和，而温疟可已。

张某，女。新产甫九日，即外出产房，而感受风寒，突然发病。自觉上身烦热不堪，汗出较多，而下身则无汗而寒冷彻骨，且口渴思饮，饮水而渴又不解。视其人面色缘缘而赤，汗出发湿而流于面。切其脉浮按之则大，视其舌色红绛而有薄黄之苔。问其二便尚正常，唯小便则黄。又问有头痛否？曰有，怕风否？曰有。

辨证：脉浮恶风为表有邪；口渴、面赤、上身烦热、汗出较多、脉按之大，为阳明气分有热之象。邪热内盛，阳阻于上，不得下达于腰膝，则下身无汗，反而觉寒冷彻骨。

治法：清热生津，兼疏卫分之邪。

处方：生石膏30克 桂枝6克 白薇9克 玉竹9克 知母9克 甘草

6克 粳米一撮

此方仅服一剂，则霍然而病愈。

四、竹叶石膏汤

竹叶石膏汤治疗伤寒解后，其人虚羸少气，气逆欲吐，不欲饮食的病证。这个方子是由竹叶、石膏、半夏、人参、炙甘草、粳米、麦门冬七味药物所组成。不难看出，此方是由白虎加人参汤减知母，加麦冬、竹叶、半夏而成方。方中用石膏、竹叶以清虚热而和胃；麦冬、人参、甘草、粳米两补气阴而扶虚羸；半夏味辛，以降气逆而治呕吐。

杨某，女，23岁。患乳腺炎，经手术治疗后，病不愈而发热39℃。西医诊断为炎症所致，用各种抗生素而发热不退，并且口腔黏膜长满霉菌，西医又恐将成败血病。其医院的医生何君，力主中医会诊，乃迎余诊视。切其脉数而无力，视其舌，因涂龙胆紫亦无法辨认。经全面了解，患者除发热外，尚有心烦、呕吐、不能食之证，唯二便尚调，精神犹佳。

辨证：乳腺炎手术后，而气液两伤。乳房内合阳明胃经，故热邪袭胃，胃气上逆，而作呕吐。今胃之气液两虚，而抗邪无力，是以病势缠绵，而治不见效。

治法：清热滋液，和胃扶虚。

处方：生石膏30克 竹叶10克 麦冬20克 党参10克 甘草10克
粳米一撮 半夏10克

此方前后共服八剂，热退身冷，呕止胃开，因而病愈。

张某，女，25岁，住某县医院。因患乳腺炎，经手术后而发热在38.5~39.5℃之间。西医认为手术后感染，注射各种抗生素而无效。后用“安乃近”发汗退热，然旋退旋升，不能巩固。因为手术之后，又几经发汗，患者疲惫不堪。症见：呕吐而不欲饮食，心烦，口干，头晕，肢颤。切其脉数而无力，舌质嫩红而苔则薄黄。余问医院主治医曰：此何病耶？答曰：此乃败血病，不知中医能治愈否？余曰：患者已气阴两伤，犹以胃液匮乏为甚，而又气逆作呕，不能进食，则正气将何以堪？必须清热扶虚，而气阴两顾，方为合法。

处方：生石膏30克 麦冬24克 党参10克 炙甘草10克 粳米一

撮 竹叶10克

此方仅服四剂，则热退呕止，而胃开能食。

综上两案分析，凡患乳腺炎手术后，多并发阳明气分之热充斥不退，而又使气津两伤，胃逆作呕等证。抑属于续发手术后的规律之一欤？书之以供临床家之参考。

五、白虎加苍术汤*

白虎加苍术汤，出自《伤寒类证活人书》。这个方子是治疗湿温病的，症见：身重，胸满，头疼，妄言，多汗，两胫逆冷等。本方由石膏、知母、甘草、粳米、苍术五药而组成。此方用白虎汤清温热气分之邪，加苍术以祛湿中之湿邪，而能除湿浊之凝滞。《医宗金鉴》在此方中又加茯苓以利湿，值得参考。

甘肃周某，男，24岁。病发热，头痛身疼，胸中发满，呕恶不欲饮食。西医曾注射“安乃近”两支，汗出甚多，而发热不退，体温为39.6℃，并时时作呕，睡则谵语，脉浮而数，舌苔则白腻。余见证有胸满作呕与苔腻之证，辨为湿温蕴于上中二焦所致，因拟三仁汤一贴。患者服药后，而发热不退，至下午则体痛不可耐，其家人督促再诊。切其脉濡数，舌赤而苔白黄杂腻，面缘缘而赤，且口渴思饮，两足反冷，小便黄赤，而大便不燥。余细思此病，曾经发汗，阳明津液受损可知；而口渴喜饮，睡则谵语，则热在阳明无疑。然而热虽甚而无汗，身痛而重，胸满作呕，足冷尿黄，舌苔又腻，则热中夹湿，湿阻气机而又昭然若揭。此证非白虎不足清其热，非苍术则不能祛湿化浊而使邪解。

处方：苍术9克 生石膏30克 知母10克 甘草6克 粳米一大撮

此方仅服一剂，则热退痛止而瘳。

六、玉女煎*

玉女煎是张景岳的方子，它治疗阴虚胃火齿痛等证。这个方子由生石膏、知母、熟地、麦冬、牛膝五药所组成，即白虎汤减甘草、粳米，加熟地、麦冬、牛膝。此方也治疗温病的气血两燔证，则熟地应改为生

地，而删去牛膝方妥。

郭某，女，38岁。牙疼龈肿，鼻时衄，心烦口干，欲思冷饮，然大便不燥，小便则黄。切其脉洪大，舌红少苔而干。

辨证：阳明气分有热，日久不治，而入于血分，故牙痛而又鼻衄也。

治法：两清气血之燔热。

处方：玉女煎加减。

生石膏30克 知母10克 生地10克 麦冬12克 牛膝6克 丹皮10克

服两剂而诸证皆愈。

七、化斑汤*

化斑汤是吴鞠通的方子。它治疗太阳温病误用辛温之药发汗，汗不出者必发斑疹；汗出过多必神昏谵语。若发斑者，则用此方治之。本方由生石膏、知母、甘草、玄参、犀角、白粳米六味药所组成。吴鞠通解此方曰：“此热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘法也。前人悉用白虎汤作化斑汤者，以其为阳明证也。阳明主肌肉，斑疹遍体皆赤，自内而外，故以石膏清肺胃之热；知母清金保肺，而治阳明独胜之热；甘草清热解毒和中；粳米清胃热而保胃液……本方独加玄参、犀角者，以斑色正赤，木火太过，其变愈速，但用白虎燥金之品，清肃上焦，恐不胜任，故加玄参启肾经之气，上交于肺，庶水天一气，上下循环，不致源泉暴绝也。犀角咸寒，禀水、木、火相生之气，为灵异之兽，其阳刚之体，主治百毒。取其咸寒，救肾水以济心火，托斑外出，而又败毒避瘟也。再病至发斑，不独在气分矣，故加二味凉血之品。”

白虎汤的加减方证还有很多，限于篇幅，不再繁引。如能从上述诸方而识其加减治疗之意义，则圆机活法，妙在一心，随证化裁，岂又以上数方所能尽。

第九讲 试论承气汤类的加减证治

承气汤类，指的是大承气汤、调胃承气汤、小承气汤、麻子仁丸、桃核承气汤、厚朴七物汤、厚朴三物汤、厚朴大黄汤、大黄硝石汤、大黄牡丹皮汤、三一承气汤、黄龙汤、增液承气汤等13个方剂。这13个方剂，以大承气汤为代表，其余12个方子，皆在大承气汤基础上加减变化而成。

一、大承气汤

大承气汤是治疗阳明病腑气实而燥屎已成的病变，必须具有腹部痞满，大便燥坚的证候特点方可使用。

我认为：“大便硬”是小承气汤的主证，而“大便燥”方是大承气汤的主证。两证虽皆有大便不通，但程度有轻重之分。正如第215条所说：“阳明病，谵语有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但硬耳”。从这段文字可以看出，“燥屎”与“大便硬”的概念并不相同。“大便硬”指的是大便干硬，而犹能成条；“燥屎”指的是大便成球，而不是成条，所以才叫“燥屎五六枚也。”它反映了燥热灼津，糟粕凝结，形同羊屎，嵌顿于肠而不得排出体外。此证燥热已深，腑气阻塞，故可五六日，甚至十余日而不大便，以致腹满疼痛，或见绕脐作痛，腹满不减，虽减亦不足道。此证肠实而胃满，腑气受阻，故反不能食；燥热内焚，除伤自身津液而见汗出、潮热、谵语以外，还要下劫肝肾之阴，出见“目中不了了，睛不和”等伤阴证候。

大承气汤证范围为广，限于篇幅，不能列举，请参照前面的《试论六经病提纲证的意义》，互相对参，则庶几近之。

大承气汤在《伤寒论》中凡十九见，所以，它比调胃承气汤、小承气汤的治疗范围宽广。为此，如果掌握了大承气汤证的辨证知识，而对于阳明病的各种胃实之证，就会起到触类旁通、举一反三的功效。

大承气汤由大黄（酒洗）、厚朴（炙）、枳实（炙）、芒硝组成。

方用大黄泻下热结，荡涤肠中燥屎；芒硝咸寒，软坚润燥，协大黄以泻下燥屎；厚朴理气除胀，枳实破气消痞，并相互配合，以推动硝、黄的泻下作用。此方泻热破坚，荡涤肠胃，攻逐六腑，其力甚大，故名为大承气汤。

调胃承气汤及大、小承气汤均以承气命名。“承气”，即承顺胃气下行而制其过亢的意思。因为腑气不得通顺在于胃肠的燥热内结，而三承气汤均有泻下实热，以使腑气舒顺、胃气得以下行的作用，故以“承气”而名汤。

解放前治一李姓患者，年35岁，以卖布为生。夏日天热，走街串巷，不停地叫卖，而辛苦非常。一日病下痢，腹痛而肛门似烙，而又下重难通，其母乃以“十滴水”与服。服后当时腹痛似有减轻，下痢已控制不发，乃认为病愈。至第四天，而腹痛又发，较前为重，下痢皆为红白黏液，腹中窘急而又有排泄不尽之感。切其脉沉而有力，视其舌苔黄而厚，以手压其腹则叫痛。

辨证：此为胃肠积热，又误用“十滴水”热性药物，反使邪热凝结不开，以致腐化气血，为红白之痢。腑气凝聚，秽物不出，故腹痛为甚。治应通因通用，以荡涤肠间滞结为法。

处方：大黄10克 元明粉10克（后下） 枳实6克 厚朴6克 滑石10克 青黛3克 甘草3克

服一剂，大便泻下数次，为黏秽粪便。从此腹痛不发，神疲思睡而下痢因愈。

二、小承气汤

小承气汤用以治疗阳明病大便已经成硬，尚未达到燥屎的程度。所以，它比调胃承气汤的燥热之邪而为深重。据胡希恕老夫人的意见，其认为小承气汤的燥热病变应在于小肠阶段，其说可供参考。

小承气汤证的形成，概括地讲，可有两种情况：一是太阳病经汗、吐、下等法治，伤了津液，邪热入里，胃肠干燥失于濡润，而使大便成硬。胃肠燥热很盛，劫迫津液而从小便旁渗，不能调节胃肠之燥，故以大便燥结，小便却反频数为其特点。另一种情况是阳明病里热盛，逼津外渗则汗出偏多；汗出多则津愈伤，以致胃肠干燥则大便成硬。

小承气汤在《伤寒论》中凡十八见。它以治疗阳明病大便成硬造成

的腹部胀满、谵语、心烦而脉滑数等证为主。小承气汤由大黄（酒洗）、枳实（炙）、厚朴（炙）组成。方中大黄苦寒以泻下阳明燥热之结，厚朴苦温以消腹满，枳实苦寒以泄痞气。两药合用则能导滞下行，有助于推动大黄的泻下作用。本方的治疗是走而不守，故泻下之力比调胃承气汤为强，但较大承气汤为缓，故取名曰小承气汤。

陈某，男，12岁。端午节吃凉粽子多枚，翌日胃疼腹胀，啼哭不止。其父在药店购买“一粒丹”成药服之不应，且疼痛转甚。乃请余诊治。切其脉沉滑有力，视其舌则黄白而腻。解衣观其腹膨胀如合瓦，以手按之叫哭不已。问其大便，知已三日未行。

辨证：食填太仓，胃肠阻滞，气机不利所致。

处方：大黄9克 厚朴9克 枳实9克 藿香梗6克 生姜6克

服药后不到两小时，则腹中气动有声，旋而作泻，味甚酸臭。连下两次，则腹痛止而思睡矣。转方用保和丸方加减而愈。

三、调胃承气汤

调胃承气汤用以治疗阳明燥热初结，燥热在胃而肠犹未全实的病变。它的主要证候是大便不通，而又见心烦，躁动不安，蒸蒸发热，或腹中胀满，或发生谵语等证为特点。

调胃承气汤是由大黄（酒洗）、甘草（炙）、芒硝组成。方中用大黄苦寒泄热，芒硝咸寒润燥软坚，甘草甘缓和中，使大黄、芒硝的作用缓恋于胃，起到载药于上的作用，又可补养胃气，以扶汗下之虚。徐忠可说：“仲景用此汤凡七见，或因吐下津干，或因烦满气热，总为胃中燥热不和，而非大实满者比，故不欲其速下而去枳朴；欲其恋膈而生津，特加甘草以调和之，故曰调胃。”

此方有两种服法，亦不可不知。如第29条的调胃承气汤的服法，则是“少少温服之”，意在取其调和胃气，而不欲其速下；而第70条的调胃承气汤是“煮取一升，去滓……顿服”，意在既和胃气，而又泻下大便，所以必须“顿服”而力始全。《卫生宝鉴》根据调胃承气汤治疗上焦燥热的特点，于本方加黄连、犀角，以治阳明火热上熏于面的“燎面”证，颇有疗效。余师其说，用以治疗牙痛龈肿，口臭头痛，鼻衄心烦而大便秘结的也有效。其中还有一段医话：我于1960年曾治一个心烦少寐的患者，其脉滑数，舌苔黄厚。我辨为火热扰心，心神不安之证。屡投芩连

等清热药物而病不愈，舌苔仍不退。偶忆《金匱》有“舌黄未下者，下之黄自去”的记载，乃用调胃承气汤。服药后，大便泻下，味极臭秽，然心烦顿解，夜睡甚酣，以镜照舌，则黄苔已去。

四、麻子仁丸

麻子仁丸是治疗“脾约”证的。阳明与太阴相表里，脏腑之气相通，脾为胃行其津液，而使燥湿相济，以维持脏腑的阴阳平衡。若阳明胃气强，而太阴脾阴弱，则由相互平衡合作而变成相互劫凌，则胃之强阳反凌脾之弱阴，使脾阴受约而不能为胃行其津液；津液不能还入胃中，胃肠失于润濡而发生干燥，大便因此成硬；胃气既强，燥热迫津偏渗而从下夺，故小便反数多。这种证候，多见于习惯性便秘患者，所以不能用承气汤泻下，而当以麻子仁丸润肠燥和脾阴，兼泻阳明之实，其病方愈。

麻子仁丸由大黄、炙枳实、炙厚朴、麻子仁、芍药、杏仁组成。方中用大黄、厚朴、枳实（即小承气汤）以泻阳明胃气之强；用麻子仁润肠滋燥；杏仁润燥通幽；芍药养阴和血；蜜制为丸，每服十丸，取其缓上润下之意。

曾治病人刘某，男，28岁。大便燥结，五六日一行。每次大便困难异常，往往因用力太劳而汗出如雨。口唇发干，以舌津舐之则起厚皮如痂，撕则唇破血出。其脉沉滑，舌苔黄。

辨证：此属胃强脾弱之脾约证。因脾荣在唇，故脾阴不足，则唇燥干裂。

处方：麻子仁丸一料。

服之而愈。

五、桃核承气汤

桃核承气汤治疗太阳在表之郁热随经入里，与血相结，从而形成下焦蓄血初结的病变。因为热与血结，其证属实，故少腹拘急，甚至硬痛拒按；少阴心主血脉而藏神，若血中浊热上扰少阴，心神不宁，故见烦躁，但未达到狂乱的程度，所以谓之“其人如狂”。

桃核承气汤由桃仁、大黄、桂枝、炙甘草、芒硝组成。方中大黄、芒硝泻热、软坚、破结；桃仁破瘀血以生新血，协同硝、黄攻逐瘀血；桂枝通阳行气，以利血脉之滞；甘草调胃和中，以护正气。此方含有调胃承气汤的作用，所以仍为承气汤的加减方，服后使瘀热从大便出，故方后注有药后“当微利”。

刘某，女，天津人。患病已两年，自称在产后受风，从此眼疼，少寐，视力开始下降，先从右眼开始，视力从1.2降至0.1。西医眼科诊为“中心性视网膜炎”，眼底水肿，黄斑区呈棕黑色病变。除眼病外，其人经常背部作痛，小腹右侧疼痛，每届经期，则两腿发胀，且记忆衰退、善忘，每日惊怕不安。切其脉弦滑有力，视舌质绛而有瘀斑。

辨证：下焦蓄血，肝失所禀，肝开窍于目，故视力降低而善忘。

治法：活血化瘀，逐旧生新。

处方：桃仁15克 大黄10克 丹皮10克 虻虫6克 炒水蛭6克 赤芍6克

甫服一帖，而发生脑后疼痛，且伴有跳动之感。然后，小腹作痛，大便泻下，小便溺出血样物甚多。顿感头目清晰，记忆好转，喜出望外。转方用血府逐瘀汤加石决明、茺蔚子。服六剂，视力恢复等于常人。经眼科检查，黄斑区的棕黑色病变已变浅变小，其功效之捷，出人意料。

六、厚朴七物汤

厚朴七物汤是张仲景的方子，见于《金匱要略·腹满寒疝宿食篇》。这个方子具有表里两解的作用，所以治疗腹满便秘而发热脉浮者有效。厚朴七物汤由厚朴、甘草、大黄、大枣、枳实、桂枝、生姜七药所组成，从药味上不难看出，此方是小承气汤与桂枝汤减芍药合为一方。尤在泾注解此方：“有枳朴大黄，所以攻里；桂枝、生姜，所以攻表；甘草、大枣则以其内外并攻，故以之安脏气，抑以和药气也”。

我认为：此方虽表里两解，但厚朴原方为半斤，桂枝则仅为二两，此方善治腹胀而偏于里证则不言而喻。

余曾治一男孩，年8岁。外感风寒，内夹食滞，腹中胀疼，大便不利，而头痛发热，脉来浮紧，舌苔则白黄杂腻。

辨证：伤寒夹食之证。

处方：厚朴9克 枳实6克 大黄6克 桂枝3克 麻黄3克 杏仁3克 甘草3克

服一剂即大便通达，汗出热退而安。

七、厚朴三物汤

厚朴三物汤，出自《金匮要略·腹满寒疝宿食病篇》。这个方子是治疗腹痛便秘，而六腑之气不行之证。它的药物组成与小承气汤同，唯剂量上有差别。小承气汤的厚朴为二两，而厚朴三物汤的厚朴则为八两，因而就决定了两方的治疗不同。尤在泾有两句精辟之言：“三物汤与小承气同。但承气意在荡实，故君大黄；三物意在行气，故君厚朴。”为此，若腹胀为甚，而大便闭者，应以此方为宜矣。

八、厚朴大黄汤

厚朴大黄汤是《金匮要略·痰饮咳嗽病篇》的方子。仲景用治支饮为病而胸满为甚之证。此方即小承气汤，唯大黄为六两，而厚朴一尺为异。尤在泾认为：“胸满疑作腹满。支饮多胸满，此何以独用下法？厚朴大黄与小承气同，设非腹中痛而闭者，未可以此轻试也”。

我认为支饮当有寒热之分。若支饮属于热者，饮与热凝而气塞不利，故胸满为甚，而用此汤泻热以逐饮、理气以消满，亦不无可取也。

九、大黄硝石汤

大黄硝石汤，出自《金匮要略·黄疸病篇》。仲景用治黄疸，腹胀满，小便色赤而不利，而自汗出的，此为表和里实证，当以此汤泻下湿热之滞结。

大黄硝石汤由大黄、黄柏、硝石、栀子四药所组成。不难看出，它是调胃承气汤的加减方。据尤在泾注：“腹满，小便不利而赤为里实，

自汗出为表和。大黄、硝石亦下热去实之法，视栀子大黄及茵陈蒿汤较猛也。”余在临床治黄疸而大便闭、小便黄赤而短、腹胀满而汗出者，则不用茵陈蒿汤而用此方，一次顿服，每多有效。

十、大黄牡丹皮汤

大黄牡丹皮汤，见于《金匱要略·疮疡肠痈浸淫疮病篇》。它能治疗肠痈少腹肿痞疼痛，小便自调，时时发热，汗出复恶寒，舌苔黄厚而脉弦紧有力之证。

大黄牡丹皮汤由大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝五药组成。方用大黄、芒硝泄热破结，使脓毒从大便排出；桃仁、冬瓜仁排脓逐瘀，以利血分之滞；又配牡丹皮凉血清热，消炎解痛。此方有脓则下脓，无脓则下血，故无论脓成与否，皆可使用。

徐某，男，44岁。因做痔疮手术，后又用药灌肠，因而引发左小腹（结肠部位）有一索状物，上抵胁胃，胀疼不堪，腹痛下利，带有黏液与烂肉样粪便，每日排泻五六次，而又排泻不爽；饮食减少，体疲无力。脉弦而滑，舌绛苔黄。

辨证：肠有痈脓，与湿热之邪胶结而腐蚀血气，成为“肠痈”证类。

治法：排脓泻热，疏肝利湿。

处方：大黄12克 桃仁12克 丹皮12克 冬瓜仁30克 生苡米30克 败酱草10克 青陈皮各6克 柴胡12克

此方连服三剂，泻下秽物甚多，而小腹之疼痛以及上抵胁胃之痛势，均大有减轻。

转方改用桂枝茯苓丸，另加大黄、海藻、贝母、柴胡等药。服后则大便越泻而秽物反越少，终于治愈。计服药20余帖云。

十一、三一承气汤*

三一承气汤，见于刘河间的《伤寒直格》。他说：“故《活人书》复言，大承气最紧，小承气次之，调胃承气又次之。……而缓下急下，善开发而难郁结，可通用者，大承气汤最为妙也。故今加甘草，名曰三

一承气汤。通治三承气汤证，于效甚速，而无加害也。”

三一承气汤，治大承气证腹满实痛，调胃证谵语下利，小承气证内热不便。故治伤寒、杂病、蓄热内甚、燥实坚燥而皆有效。然成无己认为：本方寄缓、峻于一方之中，非仲景之意，用之亦恐有失。可参考。

十二、黄龙汤*

黄龙汤，见于陶华的《伤寒六书》。用治里实而正虚，如自利清水、色纯青，谵语，腹痛拒按，口舌干燥，身热，神倦，或大便秘、腹满硬痛，神昏肢厥，循衣撮空，舌苔焦黄或焦黑，脉虚。

黄龙汤由大黄、芒硝、枳实、厚朴、甘草、当归、人参、桔梗、生姜、大枣所组成。方中用枳朴硝黄的大承气汤泻热通便，荡涤肠胃实热积滞，急下以存正气；人参、当归双补气血；甘草扶养胃气；桔梗开肺以通便；姜枣和中以调荣卫，并监硝黄之峻，以成攻补兼施之治。

何秀山说：“此方为失下证，循衣撮空，神昏肢厥，虚极热盛，不下必死者立法。故用大承气汤急下以存阴，又用参、归、草、枣气血双补以扶正。此为气血两亏，邪正合治之良方。”

十三、增液承气汤*

增液承气汤，是吴塘《温病条辨》的药方。它能治疗阳明温热之邪凝结胃肠，燥屎不下，阴液匮竭，正虚邪实，邪无出路的病证。

增液承气汤由玄参、麦冬、细生地、大黄、芒硝所组成。方中的玄参、麦冬、生地叫增液汤，能滋阴增液，润肠通便；又配合芒硝、大黄的软坚泻结，泄热通便，合成增液以扶正、承气以逐邪的作用。

孙某，女，67岁。右侧面颊连及颞颥作痛，痛得很重，有时哭叫之声闻于四邻。痛急则以手搦其颊，亦无济于痛。因掣及牙齿疼痛，牙齿几乎拔掉殆尽。血压为190/120毫米汞柱。两寸脉弦，关则滑大，舌红无苔。问其大便，则称干燥难解，小便则黄赤而短。

辨证：胃燥津亏，而肝胆郁火上走胆胃两经而为疼痛。然燥热非下不去，胃阴非滋不复，而佐以平肝之品，则庶能有济。

处方：玄参30克 生地12克 麦冬30克 大黄6克 元明粉6克（后下） 丹皮10克 白芍12克 甘草6克

服药两剂，泻下黑色干便数块，而疼痛见缓，夜间得睡。转方减去芒硝，加羚羊角粉1克（冲服）、石决明30克、夏枯草10克。从此，疼痛不发，而血压已逐渐下降而接近正常。

以上列举了承气汤类治疗阳明胃实之轻重不同的方剂，以及后世医家在承气汤基础上的发展。虽不能概括无余，若能一隅三反，则可触类而旁通。

第十讲 试论柴胡汤类的加减证治

一、小柴胡汤证治

柴胡汤类，指的是以小柴胡汤为代表的一组方剂。柴胡汤是治疗少阳病的主方，它以口苦、咽干、目眩的少阳腑证和耳聋、目赤、头痛、胸胁苦满的少阳经证为治疗对象。

邪客少阳之经，正邪相争于胁下，胁下属于表里之夹界，而侧于太阳、阳明两经之间。邪气进而入阴则恶寒，正气胜邪出于阳则发热。由于邪有进退，正有胜负，故病人时而发热，时而恶寒，寒来热往，热来寒往，寒热交替出现，即为往来寒热。它既不同于太阳病的发热恶寒，也不同于阳明病的但热不寒，临证之时，务须分清。

少阳属胆，而连于肝，性喜疏泄，而恶抑郁，故少阳为病，可出现胸胁苦满，默默不欲饮食等气郁之证。胆气内郁，若化火而迫胆汁上溢，则见口苦；火热伤津，则见咽干；风木为病，则见目眩等证，而作为少阳病的提纲证。太阳脉浮，阳明脉大，而少阳则脉弦，其舌苔则以白滑之象为准。

考《伤寒论》以柴胡名方的共有六方：即小柴胡汤，大柴胡汤，柴胡加芒硝汤，柴胡加龙骨牡蛎汤，柴胡桂枝汤，柴胡桂枝干姜汤。

以上六个柴胡汤，均以小柴胡汤为基础，因此，了解柴胡汤类的加减诸方，必须先了解小柴胡汤的组方意义开始，才有纲举目张的作用。小柴胡汤由柴胡、黄芩、半夏、生姜、甘草、人参、大枣七药组成。方中柴胡、黄芩两味苦药以清少阳之热，柴胡解经热，黄芩清腑热，这是治疗的功效之一。然少阳以疏泄为常，以抑郁为病，用柴胡、黄芩不但能解少阳之热，更能疏解少阳之气郁，这也是柴胡的另一功效。据《神农本草经》记载：柴胡治“肠胃中结气，饮食积聚”等病，说明它可促进六腑的新陈代谢，有消积化食的作用，因而也就具有推动少阳的枢机而和表调里的功效。柴胡一药而有三用，足见其在本方中的重要作用，故小柴胡汤以柴胡名方。

半夏、生姜这两味药都是辛温之品，能开能降，善于和胃治呕，又能外疏风寒，内消痰饮。因少阳胆病，以喜呕为多见，故以二药治呕健胃用意良深。人参、甘草、大枣这三味药都属甘温之品，用以扶正祛邪，以助柴芩之治；更能预先实脾，以杜少阳之传，实有“治未病”的意义。由此可见，小柴胡汤的七味药物以和解少阳之邪为主，而又旁治脾胃，和中扶正为辅。清解邪热，而又培护正气，不通过汗、吐、下的方法，而达到祛邪的目的，故叫做和解之法。

此方的剂量，柴胡应大于人参、甘草一倍以上，方能发挥治疗作用。若误将人参、甘草的用量大于或等于柴胡，则达不到和解少阳邪热的目的。因此，用本方时务须注意剂量的比例。

小柴胡汤的治疗范围颇广，其中值得注意的是，其退烧解热的功效尤著。宋朝的《苏沈良方》已发现它在这方面的作用见长，并进而将它的适应证归纳为四点：一是治往来寒热；二是治潮热；三是治身热；四是治伤寒差后更发热。验之临床，此说实不可忽视。《伤寒论》对小柴胡汤的临床应用，有“但见一证便是，不必悉具”的原则。个人认为“一证”和“不必悉具”应对照来看，着重在于“不必悉具”。如呕而发热，或胁下痞硬，或往来寒热，只要见到少阳主证，使人确信不疑，便当与柴胡汤，不必待其证候全见。临床使用本方，当以此为准则。

如曾治某女工，29岁。患顽固性呕吐，已三年未愈。每于食后即呕吐，呕吐物味极酸苦而挟痰涎。右胁胀满，胃脘作痛，惟二便尚调。月经前后参差不定，经行则心胸烦满而小腹胀痛。脉沉弦而滑，舌苔白滑。

辨证：此证为肝胆气郁，气郁而疏泄不利则生痰饮，使胃气失于和降，故呕吐痰涎而味带酸苦。至于舌脉之诊，也都反映少阳气郁不疏之候。

治法：疏利肝胆，清化痰热。

处方：柴胡12克 黄芩10克 半夏、生姜各10克 党参、炙甘草各6克 竹茹、橘皮各12克 香附、郁金各10克

此方共服六剂而呕吐全瘳，其后也未再复发。

《伤寒论》中以柴胡名方的方剂及后世在此基础上衍化派生出来的一些方剂，都可以看成是小柴胡汤的加减方，以下则分述各方的证治。

二、小柴胡汤的加减证治

（一）柴胡加桂枝汤

本方治少阳病兼见头痛、发热、脉浮等太阳表证，为小柴胡汤减去人参之碍表，加桂枝微发其汗而成。又能治少阳证兼有心悸、气上冲之证。

张某，女，59岁。患风湿性心脏病。初冬感冒，发热恶寒，头痛无汗，胸胁发满，心悸。时觉有气上冲于喉，此时则更觉烦躁不安，脉结。

辨证：少阳不和，复感风寒，且挟冲气上逆。

治法：两解少阳、太阳，兼平冲气。

处方：用小柴胡汤与桂枝汤合方。

服三剂则诸证得安。

（二）柴胡加芍药汤

本方治少阳病兼见腹中痛，且有拘挛之感，按其腹肌而如条索状，此乃因肝脾不和，血脉拘挛所致。为小柴胡汤减去苦寒之黄芩，加平肝缓急而疏利血脉的芍药而成，又能治疗妇女气血不和的月经不调与痛经等证。

郝某，女，学生，22岁。肝气素郁，经常胸胁发满，胃脘作痛，月经来潮时，则小腹拘挛作痛，脉弦细且直，舌苔薄白。

辨证：肝气郁结，血脉不和。肝气郁则疏泄不利而胸胁发满，胃脘作痛；血脉不和则痛经而小腹拘挛。

治法：疏肝和血止痛。

处方：柴胡12克 赤白芍各6克 甘草6克 党参6克 生姜10克
半夏10克 当归尾10克 泽兰6克

连服六剂，诸证即愈。

（三）柴胡桂枝汤

本方为小柴胡汤与桂枝汤的合方。治外有表证而见“肢节烦疼”，内有少阳气郁而见“心下支结”。故在小柴胡汤中加桂枝、芍药，使其外和营卫，内调气血，而病可愈。根据《伤寒论》的治疗精神，余用本方治疗下述三种病症每可取效。

1.治早期肝硬化

肝病患者，日久不愈，由气及血，由经及络，而出现腹胀，胁痛如刺，面色黧黑，脉来沉弦，舌质紫暗，边有瘀斑等证。化验检查，见白蛋白、球蛋白的比例倒置，麝香草酚浊度指数升高，临床诊断为早期肝硬化。用柴胡桂枝汤减去人参、大枣之补，另加鳖甲、牡蛎、红花、茜草、土鳖虫等专治肝脾血脉瘀滞、软坚消痞之药，有较好的效果。

2.治关节炎兼肝气郁

风湿性关节炎患者，有肢节烦疼，同时又因挟有肝气郁而胸胁苦满，或者胁背作痛等证，用柴胡桂枝汤疗效满意。

3.治肝气窜

肝气窜为民间土语而未见医籍记载。其证是自觉有一股气流在周身窜动，或上或下、或左或右，凡气窜之处，则有疼痛和发胀之感，此时患者用手拍打疼处，则伴有暖气、打嗝，随之则其证得以缓解。此病多属现代医学所谓的神经官能症一类，以老年妇女为多见。初遇此证，使用逍遥散、柴胡疏肝散一类，效果都不理想。后想出柴胡桂枝汤法，可两调营卫气血，而能独切病情，试之果然有效，至今已治愈数人。

（四）柴胡去半夏加栝蒌根汤

本方为小柴胡汤去半夏，并增益人参剂量，并加天花粉而成。治少阳病兼胃中津液耗伤而见口渴欲饮、舌红苔薄黄等症。临床使用，每于小柴胡汤中去半夏、生姜之燥，加天花粉以及麦冬、沙参等以滋阴养液；若其人津气两伤、口渴为甚，则宜加重方中人参的剂量。本方亦治“糖尿病”辨证属少阳不和，胃热津伤者。

（五）柴胡加茯苓汤

本方为小柴胡汤去黄芩加茯苓而成。治少阳三焦不利，水邪内停为患，症见：小便不利，心下悸动不安，脉弦，舌苔水滑并具有少阳病主证者。故于小柴胡汤内去苦寒之黄芩以免伤阳，可加茯苓、泽泻以利小便，使水邪去则愈。此方若再加白术，亦治小便不利，大便作泻，口渴，心烦等证。

由此可见，口渴一证，有津少和津聚之分，应从小便利与不利，舌苔薄黄与舌苔水滑上加以区分鉴别。

（六）柴陷合方

本方由小柴胡汤与小陷胸汤合方去人参而成。治少阳不和兼见胸热心烦、大便不畅、脉数而滑等症，又能治痰气火热交郁的胸痛、心下痛等证。服药后大便每多夹有黄涎，为病去之征。

杨某，男，25岁。因奋勇救火，吸入亚硝酸盐类的气体而中毒。症见：胸满憋气，心下疼痛，口苦，时时泛恶，大便已五日未行。脉弦滑，舌苔黄白而略厚。住院注射美兰并输氧气抢救。

辨证：此为肝之气机不利，痰气交郁于上、中二焦，故胸满及心下疼痛；少阳火郁，是以口苦而又时时作呕；大便五日未行，则六腑之气不得通顺，是以舌苔黄腻而不退。

治法：疏解肝胆气郁，兼利痰火之结。

处方：柴胡12克 黄芩10克 半夏10克 黄连10克 糖瓜蒌50克
炙甘草6克 党参6克 枳实6克

服药后，大便得下，排出黏液物较多，随之心胸顿觉爽快，口苦乃减，呕吐得除。在中西医配合治疗下，终于转危为安。

（七）柴胡姜味汤

本方为小柴胡汤减人参、大枣、生姜，加干姜、五味子而成。治少阳不和兼寒饮束肺，肺气不温，津液不布而致咳嗽，舌苔白润，脉弦而

缓之证。此方与柴陷合方相较，一治痰热，一治寒饮，两相对照则前后呼应。

（八）大柴胡汤

本方由小柴胡汤减人参、甘草，加大黄、枳实、芍药而成。治胆胃热实，气机受阻，疏泄不利而见大便秘结，胃脘疼痛，急不可待，且呕吐不止，口苦为甚，郁郁微烦，两胁胀痛，脉弦有力，舌苔黄腻等症。故不用参、草之补，而加大黄、枳实、芍药之泻，以两解少阳、阳明之邪。临床用以治疗急性胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎、急性阑尾炎及其他急腹症而辨证属少阳不和、阳明热实者，每可取效，已被中西医所公认。

赵某，女，13岁。患鼻衄不止，大便秘结，胸胁发满，口苦多呕，脉弦滑，舌苔黄。曾服龙胆泻肝汤不效。

辨证：肝胃火盛，迫血上行。

治法：泻肝胃之火，凉血而止衄。

处方：柴胡10克 黄芩6克 大黄6克 白芍12克 丹皮12克 枳实6克 生牡蛎12克 玄参12克

服一剂后，大便通畅，鼻衄未发，照方又服一剂而瘳。

李某，女，20岁。产后20天，因与邻人争吵，气恼之余而发病。症见：精神失常，或骂人摔物，或瞋目握拳，但不付诸行动。口中念念有词，时或叫唱。烦躁不寐，七昼夜目不交睫，而精神不疲。西医用“冬眠灵”等药，未能取效。患者两目发直，躁动不安，其家属称已数日不解大便，恶露亦停。脉弦滑有力，舌绛而苔黄腻。

辨证：气火交郁，兼有瘀滞，肝胃皆实之证。

治法：舒肝泻胃，活血化瘀。

处方：柴胡12克 大黄10克 枳壳10克 丹皮12克 桃仁12克 赤芍10克 山栀10克 菖蒲10克 郁金10克 香附10克 半夏10克 竹茹10克 生姜12克 陈皮10克

仅服一剂，则泻下黏腻黑色的粪便甚多。当夜即能入睡，且呼之不醒，竟有一日之久。寤而神志恢复，恶露亦下，从此病愈。

（九）柴胡加芒硝汤

本方由小柴胡汤剂量的一半，另加芒硝而成。治少阳不和兼有胃中燥热而见傍晚发潮热，两胁不适，口苦心烦等证。故用本方和解少阳兼以调和胃中燥热，然泻下之力为缓，不及大柴胡汤之峻。所用芒硝，在药煎好去滓后，于药汤内化开，再煮一二沸，下火后服用。

（十）柴胡桂枝干姜汤

本方由小柴胡汤减人参、大枣、半夏、生姜，加干姜、桂枝、牡蛎、天花粉而成。治胆热脾寒，气化不利，津液不滋所致腹胀，大便溏泻，小便不利，口渴心烦，或胁痛控背，手指发麻，脉弦而缓，舌淡苔白等症。故用本方和解少阳兼治脾寒，与大柴胡汤和解少阳兼治胃实相互发明，可见少阳为病影响脾胃时，需分寒热虚实不同而治之。余在临床上用本方治疗慢性肝炎，肝胆余热未尽而又伴有太阴脾家虚寒，症见胁痛、腹胀、便溏、泄泻、口干者，往往有效。若糖尿病而见少阳病证的，本方亦极合拍。

刘某，男，35岁。缘患肝炎住某传染病医院。突出的症状是腹胀殊甚，尤以午后为重，坐卧不安，无法可解，遂延余会诊。切其脉弦缓而软，视其舌质淡嫩而苔白滑。问其大便情况，则每日两三行，溏薄而不成形，小便反少，且有口渴之证。

辨证：肝病及脾，中气虚寒，故大便虽溏，而腹反胀。此病单纯治肝、治脾则无效。

治法：疏利肝胆，兼温脾寒。

处方：柴胡10克 黄芩6克 炙甘草6克 桂枝6克 干姜6克 花粉12克 牡蛎12克

连服五剂而腹胀痊愈，大便亦转正常。后用调肝和胃之药而善后。

（十一）柴胡加龙骨牡蛎汤

本方由小柴胡汤减甘草，加桂枝、茯苓、大黄、龙骨、牡蛎、铅丹

而成。治少阳不和，气火交郁，心神被扰，神不潜藏而见胸满而惊、谵语、心烦、小便不利等症，故用本方开郁泄热，镇惊安神。临床对小儿舞蹈病、精神分裂症、癫痫等，凡见上述证候者，使用本方往往有效。惟方中铅丹有毒，用时剂量宜小，不宜久服，且当以纱布包裹扎紧入煎，以保证安全。

一男孩，患小儿舞蹈症，久治不愈。肢体躁动不安，夜间少寐而烦，脉来弦滑，舌苔黄腻。

辨证：肝胆气火交进而阳气不潜。

处方：柴胡加龙骨牡蛎汤原方。

服药三剂后，烦躁得安，病减而能寐，遂去铅丹加生铁落，再进三剂而康复。

以上概括介绍了柴胡汤类的加减证治。除主方小柴胡汤外，虽又列举十多方，仍为举一反三而设，不能尽全，其中也参以个人临床经验，如以下四个附方的内容则多为个人的体会，故与《伤寒论》所载也不尽全合。

（十二）柴胡解毒汤*

本方由小柴胡汤减人参、甘草、大枣，加茵陈、土茯苓、凤尾草、草河车而成。治肝胆湿热日久成毒，蕴郁不解而见肝区疼痛，厌油喜素，多呕，体疲少力，小便黄短，舌苔厚腻等症。肝功化验则以单项转氨酶增高为多见。证为湿热内蕴，所以辨证的关键在于舌苔腻与小便黄短。本方是我临床多年所总结出的经验之方，可疏肝利胆，清热解毒，利尿渗湿，用于上述证候，疗效颇为显著。

（十三）三石解毒汤*

本方由柴胡解毒汤加生石膏、滑石、寒水石、双花、竹叶而成。治肝炎患者湿热之邪较柴胡解毒汤证为重，大有痹郁不开之势。除见上述肝炎证候外，其人还见面色黧黑，或者面带油垢，虽患肝病，然体重非但不减，且有所增，背臂时发酸麻胀痛，舌苔厚腻，且服药难于褪落，

脉弦缓等症。故用本方清热解毒，降转氨酶，兼退舌苔。关于这个方子，还有一段医话可述。1977年，我在某地开门办学时，曾诊一名慢性肝炎患者，见其舌苔厚腻，小便黄短，遂予柴胡解毒汤，似成竹在胸，料其必效。岂知服药六剂，诸证未减，腻苔依旧。转予方中增入芳香化浊之品，仍无济于事，竟几易其方，几经失败。阅《温病条辨》治暑湿的三石汤，乃是微若辛寒兼芳香之法，用辛凉以清热透邪，芳香以败毒化浊，对湿热胶结，热重于湿者颇为适宜，且与此证也甚合拍。遂将柴胡解毒汤与三石汤合方化裁，患者仅服药三剂，腻苔即退，而诸证也减，此即三石解毒汤之由来。可见书不可不读，而病也不可不看，读书与诊病相结合，才会有所提高与发展。

（十四）柴胡茵陈蒿汤*

本方由小柴胡汤减人参、甘草、大枣，加茵陈、大黄、栀子而成。治湿热之邪蕴郁肝胆，胆液疏泄失常，发为黄疸，症见：一身面目悉黄，色亮有光，身热心烦，口苦欲呕，恶闻荤腥，体疲不支，胁疼胸满，不欲饮食，小便黄涩，大便秘结，口渴腹胀，舌苔黄腻，脉来弦滑等，实即现代医学所谓之急性黄疸性肝炎。本方有清利肝胆湿热之功，对于此证，往往数剂即可收效。但黄疸虽退，而小便黄赤未已，或大便灰白未能变黄，仍不可过早停药，应以彻底治愈为限，以免病情反复而不愈。

（十五）柴胡鳖甲汤*

本方由小柴胡汤减大枣，加鳖甲、牡蛎、丹皮、赤芍而成。治少阳不和兼见气血瘀滞所致胁下痞硬、肝脾肿大等症，故去大枣之壅塞，而加活血化瘀、软坚消痞之药。对兼有低热不退者，于方中减去人参、生姜、半夏也每能收效。

王某，男，32岁。患慢性肝炎，症见肝脾肿大，心烦口渴，夜不成寐，腹胀而大便干燥。脉弦细而数，舌质红绛而无苔。

辨证：阴虚阳亢，血脉瘀滞，故口渴，心烦而寐差。脉弦细数，舌红绛，亦为阴虚之确征。

处方：柴胡6克 鳖甲15克 牡蛎15克 丹皮10克 赤芍10克 花粉10克 麦冬10克 生地10克 红花6克 茜草6克

以此方加减进退，约服60余剂，病情逐渐好转，终于治愈。

（十六）柴白汤*

本方由小柴胡汤减半夏、生姜，加生石膏、知母、粳米而成。治疗少阳不和兼阳明热盛而见大热、大烦、大渴，汗出而大便不秘，舌苔黄，口中干燥等症。对“三阳合病”而以烦热、口渴为甚的，当属首选之方。

秦某，男，30岁。因患高烧就诊，患者体温持续在39.6~40℃，西医检查：心肺正常，肝脾未触及，肥达反应阴性，未找到疟原虫，用过多种抗生素及解热药物无效，转中医治疗。

余切其脉则弦细而数，问所苦则称头痛，周身酸楚，骨节烦痛，伴有寒战，且口中干渴，发热有汗。视其舌，则苔白黄厚腻，咽峡红肿。

余问同道胡君：此何病耶？曰：此湿温也。应以何法治之？曰：藿、佩化浊，滑石清热，杏、苡利湿何如？曰：诚如君言，然湿不但在卫，且已进入气分，大有化热之势，故已弥漫三焦，而有“三阳合病”之象，治当以柴白汤佐以化湿为宜，若用香燥之药，恐反助热。

处方：柴胡12克 黄芩10克 知母10克 生石膏30克 板蓝根12克 苍术6克 草果6克

水煎一剂，分两次服，药后即热退汗止，从此获愈。

第十一讲 试论理中汤类的加减证治

理中汤类，指的是理中汤、丸，桂枝人参汤，甘草干姜汤三个方剂而言。这三个方子，应以理中汤为代表，其他方剂则是由理中汤加减变化而成。

一、理中汤

理中汤是治疗太阴脾气虚寒证的主方。脾居中州，依赖脾阳的运化功能而升清降浊，运化水谷精微而为后天之本。若中阳虚衰，脾阳不运，则寒湿不化，升降不利，即形成了太阴为病。其症状表现为：腹泻益甚，腹胀不减，时腹自痛，不欲饮食，脉沉迟无力，舌淡苔白。治用理中汤温中暖寒，健脾运湿，使腹泻止则病愈。

理中汤（又名人参汤），由人参、白术、干姜、炙甘草组成。方中用人参、甘草以补脾气之虚；干姜、白术以温脾寒而化湿。服理中汤后，要经一食顷的时间，须饮热稀粥一升许，避寒保温，勿揭衣被。

理中汤有随证加减之法，录之以供参考：若兼见脐上筑的（即脐上悸动之意），为肾气发动之兆，应去白术而加桂枝降逆平冲；若呕吐频繁的，为胃气上逆之候，则应去白术而加生姜和胃止呕；若腹泻为甚的，虽然有吐，还得用白术补脾以止泻；若心下悸而小便少者，则为夹有蓄饮之征，可加茯苓以利其小便；若口渴而欲饮水的，则属脾虚而津液不布，则应增加白术的剂量，补脾以行津液；若中寒甚而腹痛者，则应增加干姜的剂量以暖脾寒；若腹不疼而胀满为甚的，则应去掉白术，而加附子以助阳消阴寒之凝结。至于理中丸，它的药物同理中汤一样，只是改汤剂为蜜丸如鸡子黄大。以沸汤和丸，研碎，温服，日三丸、夜二丸为准。若服药后腹中未热者，亦可增加到三四丸，量病情轻重而定。

理中丸的适应证有二：一是治吐泻而不饮水的寒性霍乱；二是治大病瘥后，胸上有寒的“喜唾”之证。

余在青年时期，一次因食生冷而致脾寒作泻，乃就医于某老中医。诊毕授以理中丸，嘱曰：白天服三丸，夜间服二丸。余服药一日，下利依旧，腹中仍疼胀。乃问于老医，胡不效耶？曰：腹犹未热？答：未觉。曰：第服之，俟腹热则病愈矣。后果然腹中发热而病愈。当时颇奇其术之神，后学《伤寒论》理中丸的方后注，方知出自仲景之手，而更叹老医学识之博。

二、桂枝人参汤

桂枝人参汤即理中汤加桂枝。此方治疗太阳病的外证未除，而大便秘下不止，心下痞硬，表里不解的“协热利”证。《伤寒论》中的协热利有两种情况，一是表里皆热的葛根芩连汤证，二是表里皆寒的桂枝人参汤证。两者虽皆名“协热利”，但有寒、热的不同，临证之时，务须注意寒热病情，不得混淆。

陈某，19岁。头疼身痛，发热恶寒，大便作泻，每日四五次，无红白黏液，腹中绵绵作痛，切其脉浮弦而缓，舌苔薄白而润。前医用“藿香正气散”未能取效。余辨为表里皆寒的“协热利”证，遂用桂枝人参汤，令其先煮理中汤，后下桂枝，日、夜服之，两剂而愈。

三、甘草干姜汤

甘草干姜汤就是甘草和干姜组成的方子。但甘草必须蜜炙，干姜必须炮黑，甘草的剂量应大于干姜一倍之上。此方在《伤寒论》治疗误发少阴之汗，而手足厥冷之证；在《金匱要略》则治疗肺痿吐涎沫，不渴，遗尿，小便频数，头目眩晕，而多涎唾之证。总的来说，此方温肺、脾两太阴之寒，达阳气、行津液为其所专，临床疗效较佳。据余所知，经方中用两味药组方治病的，有桂枝甘草汤之治悸，芍药甘草汤之治挛，甘草干姜汤之治寒，赤石脂禹余粮汤之治利，皆是药简效专，用之令人称奇。

刘某，男，30岁，小学教师。患遗尿症甚久，日则间有遗出，夜则数遗无间，良以为苦。医咸认为肾气虚损，或温肾滋水而用桂附地黄汤；或补肾温涩而用固阴煎；或以脾胃虚寒而用黄芪建中汤、补中益气汤。其他鹿茸、紫河车、天生磺之类，均曾尝试，有效有不效，久则依

然无法治。吾见前服诸方于证未尝不合，何以投之罔效？细诊其脉，右部寸关皆弱，舌白润无苔。口淡，不咳唾涎，口纳略减。小便清长而不时遗，夜为甚，大便溏薄。审系肾脾肺三脏之病，但补肾温脾之药，服之屡矣，所未能服者肺经之药耳。复思消渴一证，肺为水之高源，水不从于气化，下注于肾，脾肾而不能约制，则关门洞开，是以治肺为首要，而本证亦何独不然。景岳有说：“小水虽利于肾，而肾上连肺，若肺气无权，则肾水终不能摄。故治水者必先治气，治肾者必先治肺”。本证病缘于肾，因知有温肺以化水之治法。又甘草干姜汤证原有遗尿之源，更为借用有力之依据，遂给予甘草干姜汤。

炙甘草24克，干姜9克（炮透），日二帖。三日后，遗尿大减，涎沫亦稀。再服五日而诸证尽除。然以八日服药16帖，竟愈此难治之证，诚非始料所及。

引自《赵守真医案》

第十二讲 试论四逆汤类的加减证治

四逆汤类是以四逆汤为代表的加减方类。它包括了四逆加人参汤，通脉四逆汤，通脉四逆加猪胆汁汤，白通汤，白通加猪胆汁汤，干姜附子汤，茯苓四逆汤，附子汤八个方剂。

一、四逆汤

四逆汤是治少阴病阳虚寒化证的。少阴病的阳气为一身阳气之总司，阳气有腐熟水谷，蒸化输布水液的作用。少阴阳虚，不能腐熟水谷，不能气化津液，因而或见下利清谷；或致寒饮停聚于膈上，使人干呕欲吐而又无物吐出；阳虚不达四末，故手足发凉，甚则出现四肢厥逆等证。《伤寒论》第281条说：“少阴之为病，脉微细，但欲寐也”。所以，少阴病人往往出现精神不振的欲寐而又不能熟寐的“但欲寐”之证。夫六经为病，惟少阴病证最难辨。仲景所述少阴病的脉微细，但欲寐，小便数而白，背恶寒，四肢厥冷等证，此皆人之易知而易辨。其所难者是，虽有恶寒，甚者反不觉寒，或但喜厚衣近火，问之则不言怕寒，殊不知厚衣近火即怕寒也。也有善瞌睡而精神不振者，实即“但欲寐”之渐，稍不留心，也极易造成误诊、漏诊，故临床切不可疏忽大意。

四逆汤由生附子、干姜、炙甘草组成。方中的生附子温少阴以回阳，干姜温中以散寒，炙甘草和中补虚，三药配伍，共奏回阳救逆之功。因其可治四肢厥逆，故名之以四逆汤。四肢厥逆，乃因真阳衰微，阴邪势盛，阳气不充于四肢，阴阳不相顺接而致。

罗某，男，50岁。夏日天热，汗出颇多，自觉躁热而渴。夜又行房，口渴更甚，乃瓢饮凉水甚多。未几，觉小腹窘痛，阴茎也向里抽缩，手足发凉。自觉病情严重，乃邀余诊。切其脉沉而弱，视其舌淡嫩而苔白。此乃少阴阳虚而复受阴寒之重证。

处方：附子12克 干姜10克 炙甘草10克 小茴香6克 萆澄茄6克
服一剂则痛止而病安。

二、四逆加人参汤

四逆汤治阳虚阴盛而见恶寒，脉微，下利为甚之证。若因下利津液内竭，无物可下，而下利自止的，则以四逆加人参汤治疗为宜。四逆加人参汤由炙甘草、生附子、干姜、人参四药组成。方用四逆汤补阳虚以胜阴寒，加人参生津益气，以补下后之虚。正如魏荔彤所云：“于温中之中，佐以补虚生津之品，凡病后亡血津枯者，皆可用也，不止霍乱，不止伤寒吐下后也”。

省掾曹德裕男妇，二月初病伤寒八九日，请罗治之，脉得沉细而微，四肢逆冷，自利腹痛，目不欲闭，两手常抱腋下，昏昏嗜卧，口舌干燥。乃曰：前医留白虎加人参汤一帖可服否？罗曰：白虎虽云治口燥舌干，若执此一句亦未然。今此证不可用白虎者有三：《伤寒论》云：立夏以前，处暑以后，不可妄用，一也；太阳证，无汗而渴者，不可用，二也；况病人阴证悉具，其时春气尚寒，不可用，三也。仲景云：下利清谷，急当救里，宜四逆汤。遂以四逆汤五两，加人参一两，生姜十余片，连须葱白九茎，水五大盏，同煎至三盏，去渣分三服，一日服之，至夜利止，手足温，翌日大汗而解。继以理中汤数服而愈。

引自《名医类案》

1962年，我曾就《伤寒论》中的理论和实践的有关问题，拜访过山西省中医研究所所长李汉卿先生，李老认为在临床用四逆汤时，不论是否“亡血”，都应加人参为好。因人参大补元气而能加强四逆汤的治疗功效，所以，比单纯用四逆汤为优。谨录其说以供参考。

三、通脉四逆汤

通脉四逆汤，治少阴病里阳虚寒，下利清谷，手足厥逆，脉微欲绝等证。由于阴寒内盛，而拒阳于外，又可出现里寒外热的身反不恶寒，面色赤的“格阳”、“戴阳”证。凡少阴阳证，人皆可识，及至反常，则易混淆诊断。《伤寒六书》说：“如身不发热，手足厥冷，好静沉默，不渴，泄利腹痛，脉沉细，人共知为阴证矣。至于发热面赤，烦躁不安，揭去衣被，饮冷脉大，人皆不识，认为阳证，误投寒药，死者多矣。必须凭脉下药至为切当，不问浮沉大小，但指下无力，按至筋骨全无者，必有伏阴，不可与凉药，脉虽洪大，按之无力者，重按全无，便是阴

证”。以脉辨阴阳证之真伪，其说大可借鉴。

通脉四逆汤的药物与四逆汤相同，惟剂量则比四逆汤为大。如生附子用大者一枚，干姜的剂量也增加了一倍。另外通脉四逆汤还附有加减之法，如“面色赤者，加葱九茎；腹中痛者，去葱，加芍药二两；呕者，加生姜二两；咽痛者，去芍药，加桔梗一两；利止脉不出者，去桔梗，加人参二两”。从其加减之法，可见本证之“面色赤”，则应加葱白，而“脉微欲绝”，则又应加人参。方中虽未涉及，据理而推，亦所必然矣。

徐国桢伤寒六七日，身热目赤，索水到前，置而不饮，异常大躁，将门牖大开，身卧地上，辗转不快，更求入井。一医汹汹急以承气与服。余诊其脉洪大无伦，重按无力。余曰：阳欲暴脱，外显假热，内有真寒，以姜附投之，尚恐不能胜回阳之任，况敢以纯阴之药，重劫其阳乎？观其得水不欲咽，情已大露。岂水尚不能咽，而反可咽大黄、芒硝乎？天气燠热，必有大雨，此证顷刻一身大汗，不可救矣。于是以附子、干姜各五钱，人参三钱，甘草二钱，煎成冷服。服后寒战嘎齿有声，以重棉和头复之，缩手不肯与诊，阳微之状始著，再与前药一剂，微汗热退而安。

引自《寓意草》

四、通脉四逆加猪胆汁汤

通脉四逆加猪胆汁汤，治疗“吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝”的阴阳两虚之证。此证原为少阴寒证，因吐利交作不止，最后反体液大伤，而至吐无可吐而自止，下无可下而自断，津液匮乏之情，已一目了然。故单用通脉四逆汤，则达不到既扶阳而又滋液之目的。仲景于此时，巧妙地在原方加上猪胆汁半合，于扶阳之中，而加入沃阴增液之品，妙在以有情之物，不假造作而直补人之体液，故能药后即效，而远非草木之药所能及。吴人驹说：“汗出而厥，阳微欲绝，而四肢拘急，全然不解，又兼无血以柔其筋，脉微欲绝，固为阳之欲亡，亦兼阴气亏损，故用通脉四逆以回阳，而加猪胆汁以益阴，庶几将绝之阴，不致为阳药所劫夺也”。吴氏之说，不但说出了“亡血”之治，又说出了“将绝之阴，不致为阳药所劫夺”的两层意义。

据友人谈，程门雪先生治因食蟹为病而吐利交作，以致足胫筋脉拘急不伸者，先生每用通脉四逆加猪胆汁汤治疗。凡有猪胆汁者，则多可

获救，如一时无胆汁而服通脉四逆汤者，则疗效很不理想。由此看来，猪胆汁这味药是绝不能缺少的。如果没有猪胆汁，亦可用羊胆汁代替。

五、白通汤

白通汤治疗少阴病下利，脉微而沉伏之证。此证乃是寒邪直中少阴，阴盛抑阳，以致阳气既不能固其内，又不能通于脉，而处于既虚且抑的状态，而比一般寒证为甚，故以白通汤扶阳破阴。

白通汤由葱白、生附子、干姜组成。方中干姜、附子温经回阳以散寒；葱白辛滑性热，能通阳气破阴寒，用于温阳剂中，可疏通被郁之阳气，故名曰“白通汤”。

钱潢说：“盖白通汤即四逆汤，而以葱易甘草。甘草所以缓阴气之急，和姜附而调护中州；葱则辛滑行气，可以通行阳气，而解散寒邪，二者相较，一缓一速，故其治也颇有缓急之殊也”。

林某，60岁。因食冷物病泻，每日四五次，腹中冷痛幽幽，脉沉而伏，极不易辨，而手足亦厥冷。先给四逆汤方，服后腹痛似少减，而脉仍如故，泻亦未止。因思仲景有“少阴病，下利，白通汤主之”之说，想正为此证而设。

处方：附子15克 干姜10克 葱白5茎

服一剂，即脉起手温，再服一剂，则泻止而病愈。

徐水县某女，患“雷诺病”，十指青紫，冷痛如冰，前医用当归四逆汤等效不显。切其脉极沉，而舌质亦淡。

处方：附子10克，干姜6克，葱白4茎。

服一剂而手指冷痛见缓，又服一剂而痛见止。然咽喉因肿疼，因此不敢再用白通汤以治指端冷痛，因而停药。对该方远期疗效，尚待观察。

六、白通加猪胆汁汤

白通加猪胆汁汤治疗服白通汤后，不但未奏效，反见下利不止，厥

逆无脉，干呕而烦等证。这种现象一方面说明阴寒太盛，对大热之药拒而不受，并更加激发寒邪而变本加厉；另一方面也说明下利之后，不仅阳气受伤，而且阴液也耗损。白通汤只能扶阳不能育阴，阴不复则脉不出，阴不敛阳，虚热浮于上，故干呕而烦。基于上述两个原因，本证的治疗就不是单纯的温热回阳剂所能胜任，而应于白通汤中加入人尿和猪胆汁，扶阳中且育阴，用苦咸寒反佐，使同气相求，引阳药直入阴中。

白通加猪胆汁汤，即白通汤加人尿、猪胆汁。人尿（一般用童便）咸寒益阴，猪胆汁苦寒滋阴兼清虚热。两药皆取之有情之品，既能续已竭之阴、滋将涸之液，又能借其性寒反佐，引阳药直入阴分，使阴阳不发生格拒，这就是“甚者从之”治法的具体运用。

必须注意的是，服白通加猪胆汁汤以后，若脉从无到有，从弱到强，说明正气逐渐恢复，阴邪逐渐消退，为向愈之象，即“脉续者生”；若脉暴然而出，或见浮散而大，或见急促无根，则是无根之阳暴脱的征象，预后多不良，因而仲景说：“脉暴出者死”。

喻嘉言曾说：“寒中少阴，行其严令，埋没真阳，肌肤冻裂无汗，而丧神守，急用附子、干姜，加葱白以散寒，加猪胆汁引入阴分，然恐为药力不胜，熨葱灼艾，外内协攻，乃足破其坚凝，少缓须臾，必无及矣，此一难也。若其人真阳素扰，腠理素疏，阴盛于内，必逼其阳亡于外，魄汗淋漓，脊项强硬，用附子、干姜、猪胆汁，即不可加葱艾熨灼，恐助其散，令气随汗脱，而阳无由内返也。宜扑止其汗，陡进前药，随加固护腠理，不尔，恐其阳复越，此二难也。用附子、干姜以胜阴复阳者，取飞骑突入重围，搴旗树帜，使既散之阳望而争趋，顷之复合耳。不知此义者，加增药味，和合成汤，反牵制其雄入之势，必至迂缓无功，此三难也”。喻氏“温补不可少缓”之说，颇能道出治阴寒病的关键，实有参考价值。

七、干姜附子汤

干姜附子汤，治疗太阳病，下之后，复发汗，而使表里阳气受伤，阳气伤则阴气盛。阳主昼，阴主夜，也就是白天阳气旺盛，夜晚阴气旺盛。此证在白昼阳旺之时，因阳能与阴邪相争，故“昼日烦躁不得眠”；入夜阴盛，阳虚无力与阴邪交争，故“夜而安静”。阳虚阴盛，病入三阴，故不见少阳病的喜呕，阳明病的口渴，以及太阳病的头痛、脉浮等表证。脉见沉微，脉沉主里，微主阳虚。此证是“脉沉微，身无大热”而

见微热，反映了阳虚阴盛，格阳于外。证情危重，当急救回阳，用干姜附子汤。

干姜附子汤用干姜、附子大辛大热之剂，以复脾肾之阳。附子生用，取其力更猛。与四逆汤比较，本方不用甘草之恋缓，有利于使姜附迅速发挥消阴回阳的作用。此方要求煎汤一次顿服，使药力集中，收效更快。

本方治疗阴寒盛的阴躁证有效。所谓阴躁证，每见手足厥冷，脉沉微，坐立不安，而四肢躁动为甚。此证如不急温，则有亡阳的危险。然烦为阳，躁为阴，如见但躁不烦，则为有阴无阳的反映，有阴无阳，人岂能生耶？此证为“昼日烦躁不得眠，夜而安静”，是烦、躁同时并在，阳尚能与阴争，故病虽重但不主死。

八、茯苓四逆汤

茯苓四逆汤，治疗由于汗、下误施，而使阴阳俱虚，水火阴阳不能互相交济，以致阳不得阴则烦，阴不得阳则躁。本证的烦躁不分昼夜，故与阳虚阴盛的干姜附子汤证有别，也不同于阴虚阳亢的烦躁证。治疗用茯苓四逆汤，扶阳兼以救阴，凡阳虚而阴液不继者，多取此法。

茯苓四逆汤由茯苓、人参、生附子、炙甘草、干姜组成。方中用四逆汤以扶足少阴之阳，用人参、茯苓以扶手少阴之阴，阴阳双补，则水火既济，阴阳相交，而病可愈矣。

段某，素体衰弱，形体消瘦，患病一年余，久治不愈。症见：两目欲脱，烦躁欲死，以头冲墙，高声呼烦。家属诉初起微烦头痛，屡经诊治，因其烦躁，均用寒凉清热之剂，多剂无效，病反增剧。面色青黑，精神极惫，气喘不足以息，急汗如油而凉，四肢厥逆，脉沉细欲绝。拟方如下：茯苓一两，高丽参一两，炮附子一两，炮干姜一两，甘草一两。急煎服之。服后烦躁自止，后减其量，继服十余剂而愈。

引自《中医杂志》1965年第1期

九、附子汤

附子汤是治疗少阴病，得之一二日，不发热而见背部恶寒等证的。

背为阳之府，背部恶寒是阳气衰，阴气盛的征象。寒邪入里，病发于阴，阳虚而阴盛，故口不渴，而“口中和”。四肢为诸阳之本，阳虚不达四肢，所以手足发凉。阳虚阴盛，寒邪凝滞，故见身疼，骨节疼痛。

太阳伤寒，见发热、恶寒、无汗、身疼、骨节疼痛，脉必浮，属麻黄汤证；若见无热、手足寒、身疼、骨节疼痛，脉不浮而沉，则属少阴阳虚寒证。治疗可先用灸法通阳，然后以附子汤温阳益气，固本培元。

附子汤由炮附子、茯苓、人参、白术、芍药组成。方中用附子温肾以扶真阳之本，用人参大补元气，茯苓、白术配附子可温化寒湿之凝滞，又可佐人参健脾益气。芍药敛阴和血，既可缓身痛，又可制温热不伤阴。本方脾肾双补，先天后天兼顾，为扶阳固本的代表方。

第十三讲 对寒热错杂诸方综述

《伤寒论》所载的寒热之药并用方剂，概括起来有：柴胡桂枝干姜汤、栀子干姜汤、半夏泻心汤、附子泻心汤、黄连汤、乌梅丸、麻黄升麻汤、干姜黄芩黄连人参汤，一共八个方子。而柴胡桂枝干姜汤前面已经讲过，栀子干姜汤从略，生姜泻心汤、甘草泻心汤可以半夏泻心汤为代表。下面分别对各方剂进行简要叙述。

一、半夏泻心汤

半夏泻心汤是寒药、热药杂用的方子，它属于和解脾胃寒热之邪的代表方。生姜泻心汤和甘草泻心汤都是在它的方药基础上加减变化而成。它是治疗脾胃之气失和，心下痞满而挟有痰饮的一种痞证。因其挟有痰饮，故兼有呕吐之证。如结合临床观察，此证当有心下痞满、呕吐、肠鸣下利或大便不调之证。本证的产生，由于脾胃阴阳不和，升降失序，中焦之气痞塞，寒热错杂，痰饮内生之所致。故用半夏泻心汤苦降辛开，和胃涤痰为主。

半夏泻心汤由半夏、干姜、黄芩、黄连、人参、炙甘草、大枣组成。此证气机升降不利，中焦痞塞，胃气不降而生热，故方用芩、连之苦寒以降之；脾气不升而生寒则肠鸣下利，故用干姜之辛热以温之；痰饮扰胃，逆而作呕，故用半夏降逆和胃以止呕；脾胃气弱，不能斡旋上下，故以参、草、枣以补之。本方清上温下，苦降辛开，寒热并用，以和脾胃，为治心下痞的主方。

[按]心下为半表半里部位（在胸之下，腹之上），故其为病，则用泻心汤和解为宜。然小柴胡汤治在肝胆，而泻心汤则治在脾胃。两证的气机皆有出入升降不利的特点，又皆系阴阳的乖戾不和所致，若不用和解而用它法治疗，则病不能愈。尤以“心下”位于胸腹之间，乃气之上下要道，故阴阳交通不利则作痞。痞者塞也，气滞而不行，非血非水，中实无物，故按之则濡，而但气痞耳。

张某，男，36岁。素有饮酒癖好，因病心下痞满，时发呕吐，大便不成形，日三四次，多方治疗，不见功效。脉弦滑，舌苔白。

辨证：证为酒伤脾胃，升降失调，痰从中生。痰饮使胃气上逆则呕吐，脾虚气寒则大便不成形；中气不和，气机不利，故作心下痞。

处方：半夏12克 干姜6克 黄芩6克 黄连6克 党参9克 炙甘草9克 大枣七枚

服一剂，大便泻出白色黏涎甚多，呕吐遂减十分之七，再一剂，而痞与呕吐俱减。又服两剂，则病痊愈。

二、附子泻心汤

附子泻心汤，是治心下热痞，而又阳虚不能护表，兼见“恶寒汗出”之证，一般来讲，发热容易汗出，而恶寒则不易汗出。今恶寒同时汗出，反映了卫阳不足，温煦失司的情况。卫阳，就是卫外的阳气，它出于下焦，是肾中阳气所化生，达于体表，即可“温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖”。今下焦阳虚，则化生卫阳不足，失去其温煦和固护肌表的功能，则出现恶寒汗出之证，故名之为上热下寒痞，治用附子泻心汤清热痞而温阳气。

附子泻心汤是由大黄、黄连、黄芩、炮附子组成。方中用滚开水渍泡大黄、黄连、黄芩，使其以治气分之热痞；附子用水专煎，取其味厚力雄，以专补肾间阳气之虚。此方虽寒热并用，然水渍三黄，而专煎附子，则扶阳为主，而清热为兼矣。

宁乡学生某，得外感数月，屡治不愈。延诊时，自云：胸满，上身热而汗出，腰以下恶风，时夏历六月，以被围绕。取视前所服方，皆时俗清利、搔不着痒之品。舌苔淡黄，脉弦。与附子泻心汤，阅二日复诊，云药完二剂，疾如失矣。为疏善后方而归。

引自《遁园医案》

三、黄连汤

黄连汤证是属于“伤寒胸中有热，胃中有邪气”的病理变化。胸中有

热则呕吐，胃中有邪气则腹痛或下利。治以黄连汤，寒温并用，甘苦互施，以调理上下之阴阳，和解其邪。

黄连汤由黄连、炙甘草、干姜、桂枝、人参、半夏、大枣所组成。方中用黄连以清胸中之热，干姜温脾胃之寒，桂枝宣通上下之阳气，半夏降逆止呕，人参、甘草、大枣益胃安中，使之有利于斡旋上下，而调理寒热阴阳。

徐州李某，病呕吐而大便下痢，日三四行，里急后重，有红白黏液。病经一载，各处就医不愈。因事来京，经友人介绍，让我为之诊治。脉弦而滑，按之无力，舌红而苔白。

辨证：此乃寒热错杂之邪，分据脾胃上下，若只治其一，或以寒治热，或以热治寒，皆不能奏效。当寒热并用，应仿黄连汤法。

处方：黄连9克 干姜9克 桂枝9克 半夏9克 人参6克 炙甘草6克 大枣7枚

前后共服六剂，一载之疾从此而愈。

四、乌梅丸

乌梅丸是治厥阴病的主方。病至厥阴，则阴阳互相进退，以寒热错杂之证为其特点，如“消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食”等证。又因寒热错杂、上热下寒，则可表现为吐蛔、手足厥冷，叫做“蛔厥”证，都可用乌梅丸进行治疗。

乌梅丸由乌梅、细辛、干姜、黄连、附子、当归、蜀椒、桂枝、人参、黄柏组成。本方为治厥阴寒热错杂以及蛔厥证的主方。方用乌梅醋浸以益其阴，以和其阳，有和肝安胃，敛阴止渴，安蛔的作用；附子、干姜、桂枝温经扶阳以胜寒；川椒、细辛味辣性温，能通阳破阴，且能杀蛔虫；黄连、黄柏苦寒以清热烦，并伏蛔虫而治吐；人参补气以健脾；当归补血以养肝。诸药配合，使寒热邪去，阴阳协调，柔肝温脾，安蛔敛冲，是为制方之旨。方中虽寒热并用，但以温药偏多，又得乌梅酸收敛固，因而可治疗寒热滑脱之久利。用米与蜜甘甜之品为辅料作丸，不但能养胃气之虚，且可投蛔所好而作为驱蛔之诱饵。

甘肃上寨周某，女，36岁。突然发生右上腹部阵发性急剧疼痛，四肢发凉，冷汗津津，而又作呕。既往有蛔虫史。检查：面有“虫斑”，脉弦而劲，舌绛而苔褐。辨为厥阴病的“蛔厥”之证。乃按乌梅丸的方药改

为汤剂，一剂分三次服。共服两剂，则痛止人安。然因口苦甚，仍有呕吐，问其大便已数日未行。转用大柴胡汤一帖，服后泻下大便及蛔虫多条，从此而得愈。

五、麻黄升麻汤

麻黄升麻汤，治疗表邪内郁，气机不伸，上热下寒，阴阳不和之证。因其阳邪内陷，郁而不达，故使原来浮数之脉一变而为沉迟。切其下部尺脉而又不至，是乃气机受阻，而脉道不利所致。气机既阻，则阴阳气不相顺接，故手足为之厥冷。若内陷之阳邪淫于上，则上热而为咽喉不利与吐脓血之证；阳郁于上，不能主持于下，故证又见泄利不止。此证阴阳上下并受其病，而虚实寒热亦复混淆不清，故治其阴则必伤其阳；若补其虚，则又碍其邪，因而属于难治之证。然仲景出麻黄升麻汤寒热兼治，外宣阳郁之邪，内滋肺胃之阴，既清上而又温下，务使阴阳自和则病愈。

麻黄升麻汤由麻黄、升麻、当归、知母、黄芩、葳蕤、芍药、天冬、桂枝、茯苓、炙甘草、石膏、白术、干姜组成。方中用麻黄、升麻的剂量较大，用以宣发陷下阳郁之邪；用黄芩、石膏以清肺胃之邪热；桂枝、干姜通阳温中以祛寒；当归、芍药养血以和阴；知母、天冬、葳蕤滋阴降火以和阳；甘草、茯苓、白术不仅能健脾益气而止利，且能安胃和中而交通上下。此方汇合补泻寒热之品而成方，使其相助而不相悖。虽用药多至十四味，但不是杂乱无章，为治疗寒热错杂之证，寓有精当的意义。

李梦如子，曾二次患喉痰，一次患溏泄，治之愈。今复患寒热病，历十余日不退，邀余诊。切脉未竟，已下利二次，头痛、腹痛、骨节痛，喉头尽白而腐，吐脓样痰夹血，六脉浮、中两按皆无，重按亦微缓，不能辨其至数，口渴需水，小便少，两足少阴脉似有似无。诊毕无法立方，且不明其理。连拟排脓汤、黄连阿胶汤、苦酒汤皆不惬意；复拟干姜黄芩黄连人参汤，终觉未妥；又改拟小柴胡汤加减，以求稳妥。继因雨阻，寓李宅附近，然沉思不得寐，复讯李父：病人曾出汗几次？曰：始终无汗。曾服下剂否？曰：曾服泻盐三次，而至水泻频作，脉忽变阴。余曰：得之矣。此麻黄升麻汤证也。病人脉弱易动，素有喉疾，是下虚上热体质。新患太阳伤寒而误下之，表邪不退，外热内陷，触动喉病旧疾，故喉间白腐，脓血交并。脾弱湿重之体，复因大下而成水

泻，水走大肠，故小便不利；上焦热盛，故口渴；表邪未退，故寒热头痛、骨节痛各证仍在；热闭于内，故四肢厥冷；大下之后，气血奔集于里，故阳脉沉弱；水液趋于下部，故阴脉亦闭歇。本方组成有桂枝汤加麻黄，所以解表发汗；有苓、术、干姜化水利小便，所以止利；用当归助其行血通脉；用黄芩、知母、石膏以消炎清热，兼生津液；用升麻解咽喉之毒；用玉竹（即葳蕤）以祛脓血；用天冬以清痰脓。明日即可照服此方。李终疑有败征，恐不胜麻、桂之温，欲加丽参。余曰：脉沉弱肢冷是阳郁，非阳虚也，加参转虑掣消炎解毒之肘，不如勿加，经方以不加减为贵也。后果愈。

引自《陈逊斋医案》

六、干姜黄芩黄连人参汤

干姜黄芩黄连人参汤是治疗上热下寒的寒热格拒而发生的“食入口即吐”，以及下利为甚的吐利交作之证，所以用本方清上温下而两治寒热。

干姜黄芩黄连人参汤，由干姜、黄芩、黄连、人参组成。方中用黄芩、黄连以泄上热，用干姜温脾以去寒，人参健脾以补虚。本方寒热并用，苦降辛开，干姜又可引导芩、连，使热邪不发生格拒。所以，有的注家认为，此方也治“火逆”的呕吐。

于某，男，29岁。夏月酷热，贪食寒凉，因而吐泻交作，但吐多于泻，且伴有心烦、口苦等证。脉数而滑，舌苔虽黄而润。

辨证：此为火热在上而寒湿在下，且吐利之余，胃气焉能不伤，是为中虚而寒热相杂之证。

处方：黄连6克 黄芩6克 人参6克 干姜3克嘱另捣生姜汁一盅，兑药汤中服之。

一剂即吐止病愈。

总之，《伤寒论》的寒热错杂方剂，是张仲景对方剂学的一大创举，其科学价值很高，我们应当很好地继承与发扬。以上所讲的七个寒热并用的方子，在治疗上虽皆有调和阴阳、和解寒热之邪的作用，但它们又有各自的特点。例如：半夏泻心汤虽调和阴阳而功在治痞；干姜黄芩黄连人参汤虽调和阴阳而功在治呕；乌梅丸调和阴阳而功在治蛔；麻黄升麻汤调和阴阳而功在发汗；附子泻心汤调和阴阳而功在扶阳止汗。

这些均体现出中医学同中有异，随证施治的特点。

第十四讲 使用经方的关键在于抓住主证

《伤寒论》的内容，多能理论联系实际，理法方药兼备，形成辨证论治的体系，使人越读越有味，越用越想用，成为后世医学的规范。它对发展中医学，指导临床实践，作出了巨大的贡献。

《伤寒论》实载113方（佚1方）。其方结构比较严谨，药味精炼，配伍有度，煎服得法，比起《内经》13方，有了新的发展，故被后世医家所推崇，获有“医方之祖”的称号。

辨证论治是中医必须遵循的准则。理法方药的统一，更是取得疗效的关键，所以，经方运用得当，往往效如桴鼓。

为了正确运用经方，现谈谈个人体会——使用经方的关键在于抓住主证，希望得到读者们的重视，以期对学习和使用《伤寒论》方有些裨益。

一、什么是主证，为什么要先抓主证

《伤寒论》总结了六经辨证的规律，并于每一方证中又厘定了主证、兼证、变证和夹杂证的层次，为正确地运用辨证论治提供了先决条件。

临床辨证，要先抓主证。因为主证是纲，纲举而目张，兼证、变证、夹杂证等也就迎刃而解。

什么是主证？主证是指决定全局而占主导地位的证据。如以六经的提纲证而言，则有太阳病的脉浮、头项强痛而恶寒的主证；阳明之为病的胃家实的主证；少阳之为病的口苦、咽干、目眩的主证；太阴之为病的腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛的主证；少阴之为病的脉微细，但欲寐的主证；厥阴之为病的消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不

欲食，食则吐蛔的主证。如以方证而言，则有以发热、汗出、恶风为主的桂枝汤主证；以恶寒无汗、身痛气喘为主的麻黄汤主证；以口苦喜呕、胁痛胸满、往来寒热为主的小柴胡汤主证；以烦渴、汗出、高热、脉大为主的白虎汤主证；以不大便、腹满痛、潮热谵语为主的大承气汤主证；以吐利腹满、饮食不振、自利益甚为主的理中汤主证；以四肢厥冷、下利清谷、脉微细为主的四逆汤主证；以消渴、气上撞心、饥而不欲食、食则吐蛔为主的乌梅丸主证。

六经方证的主证是辨证的关键，反映了疾病的基本规律，是最可靠的临床依据。因此，我们对主证要一抓到底，抓而不放，才有实际应用的价值。只有先抓主证，才符合辨证的思维方法，才能进一步认清兼证和变证，分清辨证的层次，而使辨证的程序井然不紊。

二、抓主证，也要注意兼证

那么，什么是兼证？兼证必须在主证的前提下出现，它附于主证而存在，但又补充了主证证候的不足。凡在主证基础上而见新的证候的，就叫做兼证。举例而言，如桂枝汤的主证为发热、汗出、恶风。若兼见

气喘，或者兼见项背强^{几几}等，这便是桂枝汤的兼证。兼证同主证的关系起到了互相为用、相得益彰的效果。但是必须指出，如果属于六经提纲证的主证，而出现另一经兼证的，则往往属于合病与并病的范围，就不能按兼证来看待。如太阳病的提纲证，而又出现胸胁苦满的证候，则多为太阳与少阳并病。如果太阳病的脉浮身痛和阳明病的心烦、口渴同时出现，则叫“二阳合病”。为此，我们所说的兼证，并不是合病与并病，两者必须分开而不能相混。兼证还有一个特点，就是它和主证有着千丝万缕的联系，是自然形成的证候，所以它离不开本经发病的范围。

如桂枝汤兼证的喘和项背强^{几几}，都和中风表不解有关。因此，它和合病、并病的实质不同。

为此，如果我们只知抓主证，而对兼证不顾，就不能做到随证应变，也不能随着兼证的出现，制订有效的治法。我认为主证和兼证是并行而不悖的关系，主证反映病之常，兼证则反映病之变。做到知常达变，方足以尽辨证之能事。

三、变证的形成及其临床意义

主证和兼证都随六经方证而出现，它们在病机上比较一致，分歧并不太大，其来龙去脉也较清楚，所以有规律可循。至于变证则不然，它不受六经为病范围所约束，而以独特地灵活多变的姿态出现，它包括了伤寒以外的许多杂病。

那么，什么是变证呢？变证是指太阳病或者少阳病，由于医生误治，使原有的主证已罢，而变生他证，不能以正证名之，就叫变证。

《伤寒论》约有三分之一的内容是论“变证”的。变证是被医生治坏的病。例如太阳病，在治疗上没有发汗，而误用了或吐、或下、或火的各种治法，由于治疗的差错，使原来的表证不复存在，而新的变证从此油然而生。变证在临床确有其事，对它的论述，也是十分必要的。但我反复地思考，感到《伤寒论》记载的误治“变证”，有的（不是全部）是著者借用它来讲另一个病的，因而未必都实有其事。例如：《伤寒论》的63条至70条的内容（指赵本条文号码），是围绕五脏病的虚实寒热加以辨证的，是属于著者精心安排的，不可能是临床误治的巧合。所以，对误治的“变证”也要一分为二，真的也有，造作的也有，不能绝对化。如果我体会不差的话，那么，就应把误治的着眼点放在辨变证的上头，不必拘于误治的形式和过程。如能这样去看，就跳出了误治的框框，自有海阔天空，鸟瞰全局之快，也就自然不再盯着汗、吐、下条文不放，做“守株待兔”那样的傻事了。

为此，对于变证，宜从辨证的前提出发，抓辨证的大方向，以达到在伤寒中论杂病的目的。

四、夹杂证形成的特点

什么是夹杂证呢？这必须从两种情况进行叙述，才能畅达其义。

1.疾病的发生发展比较复杂，往往涉及许多方面的因素，应当考虑很多的问题。伤寒也是如此，尤其是它与杂病的关系很密切。不知道这一点，就体会不了《伤寒论》辨证论治的地位。所以，对疾病不能孤立地、片面地去认识。比如《伤寒论》的夹杂证，除小建中汤和炙甘草汤治夹虚证外，还有夹饮气的小青龙汤证，夹宿食的大承气汤证，夹里寒的桂枝人参汤证，挟上热而下寒的黄连汤证等等，不胜枚举。

2.疾病的发生、发展，由于人体的体质不同，如体质的强弱，脏腑的厚薄，性别的男女，年龄的老幼，居住的南北等等差异，决定了感邪虽一，发病则殊的现实。所以，不能尽在外感上求原因，还必须从个体差异找根据，这就涉及夹杂证的实质问题。基于病有夹杂的特点，形成了新病与老病、标病与本病、表病与里病的交叉出现，使证情的变化比较复杂，在治疗上有其差异性。概括而言，《伤寒论》除以六经辨证方法外，又应分主、兼、变、夹杂四种证候，这就使辨证有了层次，有了先后，提高了对辨证的认识。

五、抓主证，使用经方的治例

《伤寒论》言不虚发，句句皆有实践根据。我们一定要细致地抓好主证，才能在实践中发挥作用，更好地指导临床治疗。为了说明抓主证用经方的重要意义，试以个人的临床治例说明如下：

（一）小承气汤证

甘肃张某，男，小学教员。自述身体太虚，来求补药。曾服人参健脾、十全大补等丸药，病不愈而体虚更甚。自觉头晕少神，四肢倦怠不欲劳动，不欲饮食，强食则腹中胀痛不支，大便秘结而小便黄赤。切其脉滑而有力，舌苔黄腻。

辨证：此非虚证，乃大实而有羸候也。由于胃家实热内滞，而使胃气不顺，燥热上熏，则头目眩晕；腑气不利，则腹胀痛不欲食；气结于里，壮火食气，是以四肢无力。夫土气太过则成敦阜，必以泻药平之而方能愈也。

处方：厚朴15克 枳实10克 大黄10克

服药一剂，大便泻三次，周身顿感轻爽，如释重负，而腹胀头晕均蠲。

（二）吴茱萸汤证

丁某，男，53岁。主诉胸胁苦满，胃脘痞胀为甚，饮食减少，食后则胃胀更甚，口中多涎，呕吐涎沫，而头昏眩不爽，脉弦缓无力，舌苔水滑。

辨证：此为厥阴寒证。厥阴寒邪则多动水，是以头目眩晕而吐涎沫也。《伤寒论》378条：“干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之”是矣。

处方：吴茱萸12克 生姜15克 党参10克 桂枝6克 厚朴12克
服此方获显效后，又加减变化共服六剂而安。

（三）芍药甘草汤证

贾某，男，53岁。症状是左腿肚子经常转筋，发作时聚起一包，腿疼不能伸直。同时，患侧的大脚趾也向足心处抽搐，疼痛难忍。切其脉弦，视其舌红而少苔。

辨证：阴血不滋，筋脉绌急而脚挛急。

处方：白芍24克 炙甘草12克

连服四剂，而病不发。

（四）黄连阿胶汤证

陈某，女，25岁，未婚。患月经淋漓不止已有几个月，面色萎黄，疲乏无力。心烦难寐，偶尔得睡，则又乱梦纭纭，反增疲倦。父母忧之，请为诊治。索其前服之方，率为温补涩血之品。六脉滑数，舌色红，舌尖尤甚。

辨证：心火上炎，无水以制，故心烦而难寐，因阳亢而不能入阴也。心主血脉，心火盛则血不归经，而月经淋漓不止。夫心火上炎，实由肾水之不升，故水火不济，心肾不交为本证之关键。

处方：黄连10克 黄芩6克 白芍10克 阿胶10克 鸡子黄2枚

共服五剂，月经方止，夜间得睡，心烦不发，饮食增加，其病得愈，取得了出人意料的疗效。

赵某，男，49岁。因患肝炎病来京治疗，患者口腔干涸，舌体极硬而卷伸不利，言语受到障碍。其脉沉弦，舌红绛而苔薄黄。

初诊辨为：肺胃阴虚，津液不滋所致，用叶氏益胃汤而无效。

复诊：证属阴虚津少，似无可疑，继投白虎加人参汤。然服药数剂，毫无功效可言，使人困惑不解。

三诊：详细问其饮食起居情况，知夜间睡眠不佳，而心烦至甚，且失眠之后则口干涸更为严重。余聆其言，结合心烦失眠与舌红绛的特点进行了分析，方知此证为心火上炎、肾水不能上济的病证。不清其火，则徒劳无功，乃改用黄连阿胶汤。服三剂，夜即得睡，而口舌干涸顿释。

（五）柴胡加龙骨牡蛎汤证

尹某，男，32岁。因受惊恐而患病，症状为：头晕，失眠，睡则呓语频作，胸胁苦满，自汗而大便不爽，并时发癫痫。望其人神情呆滞，面色青，舌质红，苔白而干，脉沉弦。

辨证：头晕、胸满、脉弦，证属少阳为病；汗出不恶寒、大便不爽，证又兼阳明腑热之象。此病得于惊恐之余，而时发癫痫，又与肝胆之气失和有关。《伤寒论》说：“胸满烦惊……谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。”与此证极为合拍。

处方：柴胡10克 龙骨10克 牡蛎10克 生姜10克 黄芩10克 桂枝6克 半夏10克 生大黄6克 铅丹4克（布包） 茯苓10克 大枣6枚

服一剂，呓语不发，胸胁满去，精神好转。

复诊：又加竹茹10克、陈皮10克。服两剂而病愈，癫痫随之亦愈。

此证因余抓住了肝胆胸胁满和精神方面的主证，选用了柴胡加龙骨牡蛎汤，因而取得了疗效。

（六）猪苓汤证

崔某，女，35岁。因产后腹泻，误认是脾虚，曾服不少补药，而病不愈。其脉沉而略滑，舌绛、苔薄黄，下利而口渴。

初诊：作厥阴下利治之，投白头翁汤，服后不见效。

复诊：自述睡眠不佳，咳嗽而下肢浮肿，尿黄而不利。聆听之后，思之良久，恍然而悟，此乃猪苓汤证。《伤寒论》第319条云：“少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。”验之此证，小便不利，大便下利，肢肿而少寐，与猪苓汤主证颇为合拍。

处方：猪苓10克 茯苓10克 泽泻10克 阿胶10克（烔化）

此方连服五剂，小便通畅，腹泻随止，而诸症皆除。

六、小结

由上述治案可见，抓不住主证，则治疗无功，抓住了主证，则效如桴鼓。然抓主证亦非容易，往往要几经波折，才能抓住。

要做到抓主证，第一，要明伤寒之理，理明则能辨证论治，从而达到抓住主证的目的。第二，要熟读《伤寒论》原文，反复诵读，能够把主证记熟，在临床时才能得心应手。由此可见，“抓主证”是辨证的最高水平。我认为，抓住主证，治好了病，也就发展了《伤寒论》的治疗范围，扩大了经方使用，使人增长了才智，就能继承和发扬祖国医学遗产，为人类健康作出更大贡献。



刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编
■ 刘渡舟 傅士垣 主编

第十辑

现代著名老中医名著重刊丛书

刘渡舟医书七种



伤寒论 诠解



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·第十辑
刘渡舟医书七种

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编



伤寒论 论解

主编 刘渡舟 傅士垣
编者 郝万山 彭桂冬 尉敏廷 徐 苓 张启文 聂惠民 毛雨泽 孙志洁

人民卫生出版社

版权页

图书在版编目（CIP）数据

伤寒论诠解 / 刘渡舟，傅士垣主编. —北京：人民卫生出版社，
2013

（现代著名老中医名著重刊丛书. 第10辑，刘渡舟医书七种）

ISBN 978-7-117-17354-4

I. ①伤... II. ①刘...②傅... III. ①《伤寒论》—研究 IV.
①R222.29

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第120944号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购
书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

现代著名老中医名著重刊丛书（第十辑）

刘渡舟医书七种

伤寒论诠解

丛书主编：王庆国 刘燕华

主 编：刘渡舟 傅士垣

出版发行：人民卫生出版社有限公司
人民卫生电子音像出版社有限公司

地 址：北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编：100021

E - mail: ipmph@pmph.com

制作单位：人民卫生电子音像出版社有限公司

排 版：人民卫生电子音像出版社有限公司

制作时间：2019年5月

版本号：V1.0

格式：mobi

标准书号：ISBN 978-7-117-17354-4

策划编辑：李丽

责任编辑：李丽

打击盗版举报电话：**010-59787491** E-mail: **WQ @ pmph.com**

注：本电子书不包含增值服务内容，如需阅览，可购买正版纸质图书。

刘渡舟医书七种编写委员会

主 编 王庆国 刘燕华

副主编 李宇航 梁永宣

编 委（以姓氏笔画为序）

于博睿 马小娜 马春雷 王 冬 王庆国

王国华 王利敏 王雪茜 刘 敏 刘丹彤

刘晓倩 刘晓辉 刘燕华 闫军堂 许仲宁

孙 燕 孙良明 孙晓东 李 欣 李成卫

李宇航 李丽娜 李晓莉 李鹏英 吴范武

张 欢 张 娜 张雪亮 陈 明 陈 萌

畅洪昇 周 刚 郑丰杰 房克英 屈会化

赵 妍 赵 琰 赵伟鹏 赵宇明 钟相根

贾春华 倪 磊 高 飞 郭书文 梁永宣

程发峰 傅延龄 鲁 艺 赛佳洋

学术秘书 闫军堂

出版说明

自20世纪60年代开始，我社先后组织出版了一些著名老中医经验整理著作，包括医案、医论、医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国现代中医学术的发展发挥了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显。这些著名老中医在我国近现代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。他们的著作多成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前。无论是亲自撰述，还是口传身授，或是由其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华。诸位名老中医不吝秘术，广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，今已很难见到，部分著作甚至已成为中医读者的收藏珍品。为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将部分具有较大影响力的名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》并分辑出版，以飨读者。

第一辑 收录13种名著

- | | |
|-------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |

《钱伯煊妇科医案》 《朱小南妇科经验选》
《赵心波儿科临床经验选编》 《赵锡武医疗经验》
《朱仁康临床经验集——皮肤外科》
《张赞臣临床经验选编》

第二辑 收录**14**种名著

《中医入门》 《章太炎医论》
《冉雪峰医案》 《菊人医话》
《赵炳南临床经验集》 《刘奉五妇科经验》
《关幼波临床经验选》 《女科证治》
《从病例谈辨证论治》 《读古医书随笔》
《金寿山医论选集》 《刘寿山正骨经验》
《韦文贵眼科临床经验选》 《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑 收录**20**种名著

《内经类证》 《金子久专辑》
《清代名医医案精华》 《陈良夫专辑》
《清代名医医话精华》 《杨志一医论医案集》
《中医对几种急性传染病的辨证论治》
《赵绍琴临证400法》 《潘澄濂医论集》
《叶熙春专辑》 《范文甫专辑》
《临诊一得录》 《妇科知要》
《中医儿科临床浅解》 《伤寒挈要》
《金匱要略简释》 《金匱要略浅述》
《温病纵横》 《临证会要》

《针灸临床经验辑要》

第四辑 收录**6**种名著

《辨证论治研究七讲》 《中医学基本理论通俗讲话》

《黄帝内经素问运气七篇讲解》 《温病条辨讲解》

《医学三字经浅说》 《医学承启集》

第五辑 收录**19**种名著

《现代医案选》 《泊庐医案》

《上海名医医案选粹》 《治验回忆录》

《内科纲要》 《六因条辨》

《马培之外科医案》 《中医外科证治经验》

《金厚如儿科临床经验集》 《小儿诊法要义》

《妇科心得》 《妇科经验良方》

《沈绍九医话》 《著园医话》

《医学特见记》 《验方类编》

《应用验方》 《中国针灸学》

《金针秘传》

第六辑 收录**11**种名著

《温病浅谈》 《杂病原旨》

《孟河马培之医案论精要》 《东垣学说论文集》

《中医临床常用对药配伍》 《潜厂医话》

《中医膏方经验选》 《医中百误歌浅说》
《中药炮制品古今演变评述》 《赵文魁医案选》
《诸病源候论养生方导引法研究》

第七辑 收录**15**种名著

《伤寒论今释》 《伤寒论类方汇参》
《金匱要略今释》 《杂病论方证捷咏》
《金匱篇解》 《中医实践经验录》
《罗元愷论医集》 《中药的配伍运用》
《中药临床生用与制用》 《针灸歌赋选解》
《清代宫廷医话》 《清宫代茶饮精华》
《常见病验方选编》 《中医验方汇编第一辑》
《新编经验方》

第八辑 收录**11**种名著

《龚志贤临床经验集》 《读书教学与临症》
《陆银华治伤经验》 《常见眼病针刺疗法》
《经外奇穴纂要》 《风火痰瘀论》
《现代针灸医案选》 《小儿推拿学概要》
《正骨经验汇萃》 《儿科针灸疗法》
《伤寒论针灸配穴选注》

第九辑 收录**11**种名著

《书种室歌诀二种》 《女科方萃》
《干祖望医话》 《名老中医带教录》
《班秀文妇科医论医案选》 《疑难病证治》
《清宫外治医方精华》 《清宫药引精华》
《祝谌予经验集》 《疑难病证思辨录》
《细辛与临床》（附 疑难重奇案七十三例）

第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）

《伤寒论十四讲》 《伤寒论通俗讲话》
《伤寒论诠解》 《新编伤寒论类方》
《经方临证指南》 《金匮要略诠解》
《肝病证治概要》

这些名著大多于20世纪60年代前后至90年代后在我社出版，自发行以来一直受到广大读者的欢迎，其中多数品种的发行量达到数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床诊疗水平和促进中医事业发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时尽可能保持原书原貌，只对原著中有欠允当之处及疏漏等进行必要的修改。为不影响原书内容的准确性，避免因换算等造成的人为错误，对部分以往的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的临床检测项目与方法等，均未改动，保留了原貌。对于原著中犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社
2013年3月

整理说明

刘渡舟是北京中医药大学已故终身教授、《伤寒论》专业首批博士生导师，当代著名的中医学大家、中医教育家。刘老行医、执教半个多世纪，上溯岐黄之道，下逮诸家之说，力倡仲景之学，博采众长，学验宏富，形成了鲜明的学术思想和医疗风格，被誉为“伤寒泰斗”、“经方大家”，日本汉方界更称其为“中国治伤寒第一人”，其学术成就为中医同仁所公认，在中医学界享有盛誉。刘老以振兴中医、培育桃李为己任，在繁忙的医疗、教学、科研之余，坚持著书立说，笔耕不辍，培养后学。刘老一生著述颇丰，曾出版中医学术著作20多部，发表学术论文100余篇，为传承中医药事业作出了杰出贡献。

20世纪80年代，刘老的学术经验日臻成熟与完善，在当时十多年的时间里，他出版了数十部关于《伤寒论》、《金匱要略》及经方运用的研究专著，具有很高的学术水平和临床应用价值，深受广大读者欢迎，在中医学界产生了很大的影响，对于推动仲景学术发展和提高中医临床水平起到了重要的作用。为了系统总结刘老的学术思想和医疗经验，并从中窥探其治学方法与道路，我们精选了最能反映刘老治伤寒、用经方、精临证的学术著作，经撰次整理，辑而成帙，名为《刘渡舟医书七种》，付梓再版，以飨读者。这7本代表性医书分别是《伤寒论十四讲》、《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论诠解》、《新编伤寒论类方》、《经方临证指南》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》。这些著作能突出反映刘老之方证相对论、辨证知机论、古今接轨论、气机论、攻邪论、水火论、湿证论、脾胃论、肝胆论以及抓主证等学术思想及其对经方的运用经验，汇集了刘老行医50余年的学术经验和心血结晶，贯彻了理论和实践相结合的方针。通过阅读刘老文稿，读者可窥其学术思想和临床经验之一斑，并有助于系统地掌握刘老的临证特色和诊治经验。编撰者也希望通过这些文字笔墨展示经方大家刘渡舟教授的学术经历及成就，使一代名家为中医药事业不屈不挠的奋斗精神、人格品质及宝贵经验得以传世后人，为中国医学史树起一座不朽的丰碑。

为了使读者能原汁原味地阅读刘老著作，本次修订再版《刘渡舟医

书七种》时，采取尽可能保持原书原貌的原则，除对原著中出现的文字、标点错误稍加更正，并在不影响文意的前提下润色语句不通顺之处外，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排，从而规范了原书的体例层次。而对原书中出现的古今字、异体字、繁简字以及以往的病名、药名、计量单位等，均未改动，保留了原貌。

2007年，为了整理、挖掘、继承和抢救京城名老中医的学术经验，北京市中医管理局启动了“名老中医药专家学术思想抢救挖掘与优秀传承人才培养联动工程”（简称“薪火传承3+3工程”），目的在于做好首都名老中医学术思想的抢救、整理和挖掘工作。刘渡舟名家研究室

（No.2007-SZ-A-09）于2007年10月首批获北京市中医管理局批准，2008年1月授牌，2008年6月正式启动建设，进行了大量卓有成效的工作。将刘老积累多年的学术著作、文章、讲稿等整理、汇编、出版更是研究室的重要工作之一，本书即是在研究室全体成员的共同努力之下完成的，在此，谨向名家研究室这一名老中医学术经验平台的发起者——北京市中医管理局致以崇高的敬意。同时，也向所有参与此次编撰工作的各位同仁致以谢意。

刘渡舟名家研究室主任
北京中医药大学副校长，教授、博士生导师
王庆国
2012年12月

前言

《伤寒论诠解》一书，主要是根据刘渡舟教授给北京中医学院1978届中医基础理论研究生讲授《伤寒论》的录音整理编辑而成。为尽量保持《伤寒论》的本来面貌和辨证论治体系的联贯性与完整性，本书选取金人成无己的《注解伤寒论》为蓝本，除对《辨脉法》、《平脉法》、《辨不可发汗病脉证并治法》等内容作了删节外，其主要部分均予保留，并按原文排列顺序，逐条加以解释。为使理法方药各项内容的解释分析相互联贯，以适合教与学的需要。本书在编写体例上简化了层次，只设“解析”一项，将内容提要、词解、病机分析以及病案举例等有关内容，尽糅其中。在解析条文时，力求保持作者的学术观点和心得体会，也适当介绍历代注家的意见。并着重在理法方药的分析、病机的探讨、病证的比较鉴别、上下前后条文之间的联系等方面，作较深入细致的阐述并有所发挥。在阐发理论的同时，尽量联系一些临床病例，力求从理论与实践的结合上说明问题。本书在编写时尽量做到内容详尽，文字通俗易懂，以便达到既可供初学者阅读，亦可供深造者参考的目的。

由于编写时间仓促，水平有限，书中难免有错漏之处，敬请广大读者批评指正。

编者
1982年1月

凡例

一、本书原文部分，谨遵金人成无己《注解伤寒论》（以人民卫生出版社1963年横排版为准，以下简称原书）一书，从卷二《辨太阳病脉证并治法上第五》至卷七《辨阴阳易差后劳复病脉证并治法第十四》，凡十篇，414条，113方（佚1方）。本书删去原书卷号和篇序，除“辨太阳病脉证并治法”分上、中、下三篇外，其他均依原书单独成篇。原书卷十所载二十五方，分别附入上述诸篇有关原文项下，本书不在方中另行说明。原书未录桂枝附子去桂加白术汤方，本书则依赵开美复刻本补入。

二、原书中习用的异体字、通假字、古体字，如藏与脏、府与腑、荣与营、虻与蛔、譌与谗、称与秤、杏人与杏仁、麻子人与麻子仁等，本书均予以保留，大多不在书中另加说明。

三、为了便于读者了解《伤寒论》全书的概况和各篇的重点内容，本书前面有“绪论”，各篇之首有“概说”，篇末附“小结”。

四、本书的解析部分，包括提要、词解以及必要的校勘（少数校勘附在原文中）、病机分析、临床意义、方解、方药临床应用、注家见解、上下条文的联系、前后方证的鉴别比较和医案举例等内容，一文相贯，均不另标题目。

五、本书在书末附有《伤寒论》原文的校勘，以便于读者在研究时检索。

目录

[伤寒卒病论集](#)

[绪论](#)

- [一、《伤寒论》的产生与演变](#)
- [二、《伤寒论》是一部什么书](#)
- [三、什么是六经](#)
- [四、六经病的传变](#)
- [五、六经病的主证、兼证、变证与夹杂证](#)
- [六、《伤寒论》的治法与方剂](#)
- [七、《伤寒论》的辨证论治精神](#)

[各论](#)

- [辨太阳病脉证并治法上](#)
- [辨太阳病脉证并治法中](#)
- [辨太阳病脉证并治法下](#)
- [辨阳明病脉证并治法](#)
- [辨少阳病脉证并治法](#)
- [辨太阴病脉证并治法](#)
- [辨少阴病脉证并治法](#)
- [辨厥阴病脉证并治法](#)
- [辨霍乱病脉证并治法](#)
- [辨阴阳易差后劳复病脉证并治法](#)

[附：《伤寒论》原文校勘](#)

- [桂枝去桂加茯苓白术汤方：](#)
- [芍药甘草附子汤方：](#)
- [桂枝甘草龙骨牡蛎汤：](#)
- [甘草泻心汤方：](#)
- [猪胆汁方：](#)
- [猪肤汤方：](#)

[返回总目录](#)

伤寒卒病论集

论曰：余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务，崇饰其末，忽弃其本，华其外而悴其内。皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震栗；降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉？而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地，蒙蒙昧昧，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也！余宗族素多，向余二百。建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横夭之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》，并《平脉辨证》，为《伤寒杂病论》合十六卷，虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源，若能寻余所集，思过半矣。夫天布五行，以运万类，人禀五常，以有五藏，经络府俞，阴阳会通，玄冥幽微，变化难极，自非才高识妙，岂能探其理致哉？上古有神农、黄帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑、扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公，下此以往，未之闻也。观今之医，不念思求经旨，以演其所知，各承家技，始终顺旧。省疾问病，务在口给，相对斯须，便处汤药，按寸不及尺，握手不及足，人迎、趺阳，三部不参，动数发息，不满五十，短期未知决诊，九候曾无仿佛，明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管而已。夫欲视死别生，实为难矣！孔子云：生而知之者上，学则亚之。多闻博识，知之次也。余宿尚方术，请事斯语。

绪论

一、《伤寒论》的产生与演变

《伤寒论》原书名为《伤寒杂病论》（或《伤寒卒病论》），为东汉张机所著。

张机，字仲景，南郡涅阳（今河南南阳邓县）人，生卒年代约公元150—219年。他曾跟随同郡名医张伯祖学医，经过多年的刻苦钻研，无论是医学理论，还是临床实践经验都胜过了他的老师，可谓是“青出于蓝而胜于蓝”。

张仲景生活于东汉末年，当时由于封建统治阶级的残酷剥削与压迫，特别是战争连年不断，以致民不聊生，疾疫广泛流行。张仲景的家庭本是一个大家族，拥有两百多人。但从建安元年以后，在不到十年的时间里，就死掉了三分之二，其中病死于伤寒的竟占十分之七。在严重的疫情，特别是伤寒病对人民生命健康造成的严重危害面前，张仲景深深感到自己作为一个医生所肩负的责任之重大，因此决心认真总结前人的医疗经验，著书立说以济世救民。自秦汉以来，在总结大量临床实践经验的基础上，祖国医学理论体系已逐步形成，并不断完善，在应用单味药的经验不断丰富的基础上，已逐步过渡到复方的广泛应用，并开始产生复方配伍的理论，医学上的这些成就，为张氏著书创造了很好的条件。

《伤寒杂病论》问世不久，由于兵火战乱的洗劫，原书已散失不全。后经西晋太医令王叔和的搜集整理，使此书才又得以保存下来，但书中内容已有所调整与增减。宋朝国家“校正医书局”高保衡、孙奇、林亿等人奉命校订医书时，考虑到“百病之急，无急于伤寒”，因此先校订《伤寒论》十卷，于宋治平二年（公元1065年）颁行于世。其后又校订了《金匱玉函要略方论》（现简称《金匱要略》）。从此，《伤寒杂病论》一书就分为《伤寒论》与《金匱要略》两部书了。

现通行的《伤寒论》版本主要有两种：一部是宋治平年间经高保衡

等人校过的刻本；另一部是南宋绍兴十四年（公元1144年，即金皇统四年）成无己的注本《注解伤寒论》。除以上两种版本外，还有一个《伤寒论》的别本《金匱玉函经》，共八卷，亦是由高保衡、孙奇、林亿等人校刻的，与《伤寒论》同体而别名。现在宋朝校订的原刻本已不可得，而仅存的是明朝赵开美的复刻本，由于它还逼真于宋治平本的原貌，故常被后来的医家所采用。成注本以明朝嘉靖年间汪济川的校刊本为佳。本书的原文部分即采用汪校本，句读多遵人民卫生出版社1963年横排本。

二、《伤寒论》是一部什么书

对《伤寒论》的认识，历代注家有不同的见解，归纳起来不外两种：一种认为《伤寒论》是辨治外感热病的专书，具体地说，是辨治伤于风寒邪气所引起的外感疾病的专书；另一种则认为《伤寒论》是一部辨证论治的书，它把一些杂病也糅在外感伤寒之中，以六经分证来统摄诸病，是论病以辨明伤寒，非只论伤寒一病。它在六经分证的基础上，察寒热，定表里，分虚实，进一步判明病变的性质、部位、邪正盛衰以及疾病发生发展的规律，从而起到了提纲挈领，执简驭繁的作用。从这个意义上讲，《伤寒论》可以说是主论外感伤寒，兼论内伤杂病，其所见者大，所包者广，它的实用价值不能低估。

为了说明本书所论述的内容，先介绍一下什么是“伤寒”。伤寒有广义和狭义之分。《素问·热论》说：“今夫热病者，皆伤寒之类也”，是指广义的伤寒，即一切外感热病的统称；而狭义的伤寒，则专指感受风寒邪气所引起的外感病证。按《难经·五十八难》所说：“伤寒有五，有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病”，《伤寒论》既然以伤寒命名，而且又分别论述了伤寒、中风、温病等多种外感病证，因此，可以说本书所论的伤寒是属于广义的伤寒。但从《伤寒论》中所涉及的主要内容来看，其重点仍在于论述狭义伤寒，因为有关温病的论述只是作为类证提出，以与伤寒作简明的鉴别和比较，并未作系统、全面的论述。

还需要指出，《伤寒论》所说的伤寒病也不同于西医所说的“伤寒”。从病变过程及临床表现来看，西医所说的斑疹伤寒或伤寒、副伤寒，多属于外感温热或湿热病一类，与中医所说的伤寒病有别，不能混为一谈。

什么是杂病？汉代以前，凡属于伤寒之外的疾病，可概称为“杂

病”。当时所说的杂病，实际上相当于今之内科、妇科等疾病。后来，虽然《伤寒杂病论》分为《伤寒论》与《金匱要略》两部书，但在辨证论治的具体内容上，仍是互相联系，互相渗透，难以截然分开的。况且《伤寒论》的六经分证，原为众病而设，并不是专为伤寒一病所用，它的辨证论治体系在临床上具有普遍的指导意义。所以，张仲景在《伤寒卒病论集》中说：“虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源，若能寻余所集，思过半矣。”

三、什么是六经

《伤寒论》是以六经作为辨证论治的纲领。六经就是太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴的统称。《伤寒论》的六经分证，继承了《素问·热论》的六经分证方法，并在此基础上吸收了汉以前有关平脉辨证与治疗的实践经验，使之更加系统与完善，更具有科学性与实践性。

《素问·热论》的六经只是作为分证的纲领，没有提出具体的辨证论治方法，从内容上看，也仅仅是论述了六经的热证和实证，未能论及六经的寒证和虚证。《伤寒论》的六经，能有机地将它所联系的脏腑经络的病变与证候加以概括，并着重用分析的方法指导辨证与治疗。具体地说，也就是根据人体抗病力的强弱，病势的进退、缓急等各方面的因素，对疾病发生、发展过程中的各种证候，进行分析、归纳、综合，借以判断病变部位、寒热性质、正邪盛衰以及治疗的顺逆宜忌等，作为诊病治疗的依据。如风寒初客于表，表现为恶寒、发热、头项强痛、脉浮等太阳经表受邪，营卫失和的证候，便是太阳病；若邪气化热入里，表现为热而不寒、口渴、汗出，甚或腹满疼痛拒按、大便燥结不下等胃肠燥热实证，便是阳明病；若邪气虽已离表，但又未入于里，与正气交争在半表半里的胁下胆经部位，表现为往来寒热、胸胁苦满、神情默默而不欲饮食、心烦喜呕、口苦、咽干、目眩等证候，便是少阳病。以上三阳经病，表示外邪侵犯人体，邪气虽盛，但正气不衰，与邪气斗争有力，表现为机能亢奋；其病变部位在表、在外、在腑；其病变性质以热证、实证为主。若病入三阴，说明机体的机能衰减，抗邪无力，寒邪入里而病于脏，表现为阳虚阴盛的虚寒证。其中，表现为脾阳虚，寒湿内困，见到吐利、腹满疼痛、喜温、喜按等证的，是为太阴病；表现为心肾阳虚，阴寒内盛，见手足厥冷、下利清谷、精神萎靡、昏沉欲睡、脉微细等证的，则属少阴病；厥阴病是六经病的终末阶段，其病证则以阴寒盛极、阳衰转复的寒热错杂证为主，表现有消渴、气上撞心、心中疼

热、饥而不欲食、食则呕吐或吐蚘、下利等证。

从以上所列举的六经病证可以看出，它既是对疾病所表现的六类证候的系统概括，又表示病变过程中的既不相同而又相互联系的六个阶段。同时也体现了六经分阴阳，阴阳又统摄表里、寒热、虚实的六经与八纲的内在联系。

下面再简单介绍一下六经与脏腑经络的关系及六经与六气的关系：

（一）六经与脏腑经络的关系

六经是人体手足十二经的统称。由于经脉分别络属于相关的脏腑，经脉与脏腑在生理病理上是相互联系、相互影响的。所以，六经病证就是脏腑经络病变的具体表现。张介宾说：“经脉者，脏腑之枝叶；脏腑者，经脉之根本，知十二经之道，则阴阳明，表里悉，气血分，虚实见……凡人之生，病之成，人之所以治，病之所以起，莫不由之。”就切实地指明了经络与脏腑的密切关系，以及通晓脏腑经络学说，对于掌握疾病的发生发展规律，判断病证的阴阳、表里、寒热、虚实，从而对其进行有效的辨证论治有着极其重要的意义。

六经病证是脏腑经络病变的反映，如三阳经病，反映了六腑的病变；三阴经病，反映了五脏的病变，在经之邪不解，可随经入里，发为腑病或脏病，如太阳经证不解，可随经入里发为太阳腑证，等等；都是对六经病证与脏腑经络关系的很好的说明。又由于经脉的沟通联系，各个经脉、脏腑之间都具有相应的表里关系，而这些具有表里关系的脏腑经脉，在发生病变时的相互联系、相互影响关系，也在六经病证中有所体现。如太阳为病，阳气抗邪于表，则出现太阳经表证；若太阳抗邪无力，而在里的少阴阳气又虚，则太阳之邪也可以内传少阴；当少阴阳气得到了恢复，有力量抗邪于外时，则病变又可由阴转阳而外传太阳。像这种具有表里关系的经脉、脏腑病证的相互联系与影响，不仅表现在太阳与少阴之间，而且也同样存在于其他六经病证之中。因此，可以从阴阳、表里、寒热、虚实等各种矛盾的运动中，去认识脏腑经络的病理变化，这就是《伤寒论》认识疾病的基本方法。从这个意义上说，六经辨证也是脏腑辨证的一个重要组成部分。

（二）六经与六气的关系

六经、六气之说，源于《内经》，用于注解《伤寒论》则以清代张隐庵为代表。他用六经六气特点，即太阳之气为寒，阳明之气为燥，少阳之气为火，太阴之气为湿，少阴之气为热，厥阴之气为风则叫做本，而以六经的三阴三阳则叫做标；在标、本之间所维系的表里关系则叫做中气（如太阳以少阴为中气，少阴以太阳为中气等）。标、本、中气在每经中的从属和变化各有不同，用这种方法来反映六经为病特点的，则叫做“气化学说”。因此，为了能深刻地理解《伤寒论》六经六气性质及其发病特点，也有必要对“气化学说”进行研究和探讨。

四、六经病的传变

伤寒六经为病，不是静止不动的，而是经常处于传变的运动之中。一般地说，凡邪气内传，则病证由表传里，由阳入阴；而正气能以拒邪外出，则病证由里出表，由阴转阳。无论病证由表传里、由阳入阴，还是由里出表、由阴转阳，都可以说是传变。所不同的是前者属邪胜病进，后者为邪衰病退，病势有轻重进退的不同。

六经病证是否传变，主要决定于人体正气的盛衰及正邪斗争的状况。正气充盛，抗邪有力，则邪气不能内传；而正气虚衰，抗邪无力，则常导致邪气内传；若邪气虽已内传，但正气在与邪气斗争中逐渐得到恢复，又具备了驱邪外出的能力，则又可使病情由阴转阳；当正胜邪却时，还可以“战汗”的形式外解。正邪力量的对比，也是相对的。六经传变不仅与正气盛衰有关，而且与邪气的盛衰也有密切关系。若感邪势盛，所向披靡，长驱直入，也必然向内传变；而邪气不甚，或在与正气斗争中变衰，则无内传之力，或虽已内传，亦可转为外出之机。由此可见，六经病证的传变是有条件的，主要取决于正邪盛衰状况。判断六经是否传变，不应以病日数计，而应凭借脉证的变化为依据，《伤寒论》中提出：“伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。”“伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。”都是很好的证明。

六经病证的发生发展，不仅有传经而来，而且也有直中的。“直中”是指病邪不经太阳初期阶段或三阳阶段，直接进入阴经的一种病变形式。如伤寒直中太阴，起病即见吐利、腹满而痛的太阴证候。直中以直中太阴、少阴为多见，直中厥阴的较少见。病邪所以能越过阳经而直中阴经为病，主要原因是正气内虚，抗邪无力。因此，凡属直中者多较

一般传经之邪为病严重。

六经可以单独为病，也就是一个经、一个经的单独发病或传变，也可以两经或者三经合并为病。其中，两经或者三经同时发病，称为“合病”，如太阳、阳明合病，太阳、少阳合病，阳明、少阳合病以及三阳合病等；若是一经病未愈，而另一经病又起，有先后次第之分的称为“并病”，如太阳与少阳并病，太阳与阳明并病，少阳与阳明并病等。从病情来看，合病多属原发，其势急骤；并病多属续发，其势较缓。

五、六经病的主证、兼证、变证与夹杂证

六经病证复杂多变。学习《伤寒论》不仅要牢牢掌握六经主证，同时还要注意六经的兼夹证和变证，这样才能有效地指导辨证治疗。以太阳病的中风证为例，发热、汗出、恶风、脉浮缓是主证，当用桂枝汤治疗；若更见项背强几几，则属太阳中风之兼证，应治以桂枝加葛根汤；若“服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者”，则是太阳中风的变证，此时不宜再用桂枝汤，应该用白虎加人参汤治疗。至于所见的各种夹杂证，多与病人脏腑的寒热虚实有关。如有伤寒二三日，由于患者中气不足，兼见心悸而烦，用小建中汤治疗的夹虚证；也有“大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛”，宿食不尽，用大承气汤治疗的夹实证。

从整个六经病证来讲，其主证可以看做是辨病之常，其兼证、变证及各种夹杂证均可看做为辨病之变。知常方可达变，熟悉各经主证的证候和治疗，对于指导各种变证、兼夹证的辨证论治有重要意义。同时，也应该看到《伤寒论》中提出的多种误治后的变证，以及患者素质与宿疾不同所反映出来的各种夹杂证，又大大地丰富并充实了六经辨证的内容，突出并加强了《伤寒论》辨证论治的思想，从而不难看出，《伤寒论》确实具有伤寒与杂病合论的这一特点。

六、《伤寒论》的治法与方剂

《伤寒论》的六经病证是复杂多变的，而与之相适应的治疗方法也是多种多样的，诸如麻桂的汗法、瓜蒂的吐法、硝黄的下法、芩连的清

法、姜附的温法、参草的补法、柴芩的和法、虻蛭的消法，等等，可以说是集汗、吐、下、温、清、补、和、消八法之大成。《伤寒论》中载方113首，用药91味，组方严谨，用药少而精，方以法立，法以方传，字字有规矩准绳，用之得心应手。

有关方剂的记载，在现存的古医籍中，最早见于《黄帝内经》，它仅载13方，远不能满足临床治疗的需要。到了汉代，由于药物的不断丰富与发展，特别是复方的广泛应用，使方剂学在配伍理论、临床实践方面，均有较大的进展。近几年出土的汉代医药木简，为我们提供了这方面的可靠的文物根据。从1972年12月在甘肃武威出土的一批东汉早期的医药简牍来看，内有医方30多个，而且几乎全是复方，用药约100种，可见当时的方药已有相当水平。虽然《伤寒论》中所载的方和药，并不全是张仲景所独创，但张仲景对于继承并发扬汉代以前的医药学遗产，将理、法、方、药一脉贯通，开创辨证论治的治疗原则方面，作出了重大贡献。《伤寒论》中的许多方剂，如桂枝汤、柴胡汤、白虎汤、承气汤、理中汤、四逆汤、乌梅丸、泻心汤等，经过了1700余年的实践考验，证明确实实用之有效。

七、《伤寒论》的辨证论治精神

《伤寒论》在古典医籍中，以辨证论治著称，辨证论治精神贯穿于全书的始终。

辨证的方法，并不是从《伤寒杂病论》开始，张仲景在《伤寒杂病论》序文中提到“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胕》、《药录》，并《平脉辨证》，为《伤寒杂病论》合十六卷”，这里的《平脉辨证》，是一部医书，已失传。日本山田正珍说：“《平脉辨证》诸书，今皆不传。”这说明汉代以前就有了辨证的学说，并为伤寒六经辨证奠定了基础。其实，作为中医学术基本特点的辨证论治精神，早在《黄帝内经》就有所体现。特别是我国古代的阴阳学说，因其具有辩证法的思想，引进医学领域之后，开阔了医家辨认疾病的眼界，并以此奠定了辨证的思想基础。《素问·阴阳应象大论》强调“善诊者，察色按脉，先别阴阳”，后世所谓的八纲辨证，以阴阳为辨证的总纲，其原因也就在此。看病时能运用阴阳的辩证思想，就能像古人说的“知丑知善，知病知不病，知高知下，知坐知起，知行知止，用之有纪，诊道乃具”，否则，就“知左不知右，知右不知左，知上不知

下，知先不知后，故治不久。”阴阳学说渗透到了祖国医学学术领域的各个方面，它不仅用以说明人体的生理功能、病理变化，而且也用以指导临床的诊断和治疗。

张仲景继承了阴阳学说，并结合临床实践，使之又有了新的发展。《伤寒论》的六经辨证，就是以阴阳为纲，即用三阳、三阴的阴阳两纲总统于六经。进行六经辨证，应首先解决病发于阴，还是病发于阳，辨明阴阳，则是治病求于本。然后，进一步探求病位之所在、病情之所属、病势之进退，而判明表里、寒热、虚实，体现了八纲辨证贯穿于六经辨证之中。

六经辨证，通过八纲认识到疾病的阴阳、表里、寒热、虚实八个主要方面，可以说是辨证中不可缺少的先决条件。但是，如果只辨到八纲为止，那还是不够的，因为它还没有具体地把人体的脏腑经络的病理变化结合起来，就好像找人只找到了街道，还没有找到住户一样，仍然不能确切而深刻地阐明各种复杂的病理变化，并指导临床治疗。而六经辨证就恰好解决了这个问题，它把八纲落实到脏腑经络上，使八纲辨证与脏腑辨证有机地结合起来，从而弥补了八纲辨证之不足。

由于六经辨证贯穿着八纲而联系于脏腑经络，尤其是以脏腑经络生理、病理变化作为物质基础，从而使辨证言之有物，而不是空中楼阁。前人在研究《伤寒论》六经时曾指出：“经者，径也”，据经则知邪的来去之路；“经者，界也”，据经则知病有范围，彼此不相混淆。有了范围，有了界限，就能使我们在辨证时一目了然。见头项强痛，可知是太阳经脉受邪；见缘缘面赤、额痛、鼻干，可知是阳明经脉受邪；见耳聋、胸胁苦满，可知是少阳经脉受邪；见腹满时痛，可知是太阴经脉受邪；见咽痛，可知是少阴经脉受邪；见巅顶痛、干呕吐涎沫，可知是厥阴经脉受邪。若离开经络学说，上述各个证候的发生与机理，就无法解释。又由于经络系统的联络交会，使人体的五脏六腑、表里上下、四肢九窍、皮肉筋脉等各个组织器官联结成为一个有机的统一整体，因此六经辨证也特别注意脏腑经络病变的相互影响。如发热、恶寒而脉浮者，是属太阳经表受邪；若脉不浮而反见沉象，则知太阳表邪而又内累少阴。太阳与少阴为表里，当少阴阳气不足而外感风寒时，可以两经同时受邪，形成太阳与少阴的“两感”证。脾与胃互为表里，在发生病变时亦相互影响，故有“实则阳明，虚则太阴”的说法。这种病变的相互影响，表现在具有表里关系的经络脏腑之间，所以，辨证不能离开经络。宋·朱肱认为：“治伤寒先须识经络，不识经络，触途冥行，不知邪气之所在。”

辨证掌握了六经，就有了规矩准绳，它是《伤寒论》的核心。在这

个基础上，张仲景又举出多种变证的辨证，用以羽翼六经辨证的不及。变证，是指误治后，证情发生了变化，甚至是治坏了的病证，它可以不受六经病的局限和传经的约束，具有很大的灵活性和机动性。《伤寒论》中大约有近三分之一的篇幅论述误治的变证，这些变证所涉及的内容也是极为广泛的，如书中提到由于汗不得法引起的变证，就有“发汗后恶寒者，虚故也；不恶寒但热者，实也”，还有“发汗后，腹胀满者”，“发汗后……汗出而喘，无大热者”，“发汗后，其人脐下悸者”，“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按者”等等，可以说寒热虚实各个方面，无所不包，面面俱到，显示了辨证的多样性和复杂性。正由于有内容丰富多彩的变证穿插在六经辨证之中，因而大大地扩展了《伤寒论》的辨证范围。

《伤寒论》的辨证论治精神，还突出地表现在把许多相互关联又互相矛盾着的证候及治法并列在一起，反复比较、鉴别，从中得出正确的结论，把人们的辨证思维引向深化。如《伤寒论》中提到的“伤寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之”；“太阳病，身黄，脉沉结，少腹鞭，小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也”；“自利不渴者，属太阴”；“自利而渴者，属少阴也”，都是通过一两个主要证候的鉴别、比较，使辨证分明。又如太阳病有麻桂的可汗法，但对“尺中迟者”、“尺中脉微”以及“咽喉干燥者”、“淋家”、“疮家”、“衄家”、“亡血家”、“病人有寒”等不同情况又提出“不可发汗”的禁忌。阳明病证虽以下法为主，但在强调攻下的同时，复列举了禁下之证；在可下与不可下之间，反复分析，反复推敲，以详辨其什么情况可攻，什么情况不可攻；什么时候是“屎未硬”，什么时候又为“屎定硬”；什么时候先用小承气汤，什么时候又必用大承气汤；什么情况下不可下而可导，又什么情况下不可攻而可润等等，真是辨证分析淋漓尽致，提出的治法多种多样，使人眼界大开，思路广阔。

综上所述，可以看出《伤寒论》的辨证论治是继承了《黄帝内经》的学术思想，把具有辩证思想的阴阳学说作为分经认证的纲，以指导对疾病的诊断和治疗；创立了六经辨证的体系，从而使其辨证内容更加丰富。辨证在于深入细致的分析，鉴别与比较，既看正面又看反面，用一分为二的方法看问题，这是六经辨证的基本方法，也是作出正确诊断和治疗的必要前提。

学习《伤寒论》，主要是学习它的辨证论治的思想和方法，要做到这一点，就必须对祖国医学的基本理论，特别是有关阴阳学说，脏腑经络的生理、病理学说要融会贯通，从其病理变化的客观反映进行分析、综合、归纳，划分所属的六经范围，制定相应的治则与治法。同时要反

复阅读原文，领会书中精神，记住辨证中的证候特点，以及方剂的宜忌、剂量大小和煎服方法。理论来自实践，同时也要接受实践的检验。学习六经辨证理论要结合临床实践，陈修园的看病与读书结合起来的主张是很有道理的，这样学习《伤寒论》收获就大。

各论

辨太阳病脉证并治法上

【概说】

太阳，主要指足太阳膀胱经、腑及其生理功能而言。太阳病则主要指外邪侵犯足太阳膀胱经、腑后所发生的病证。

足太阳膀胱经脉，起于目内眦，上额交巅，入络脑，还出别下项，挟脊抵腰中，入循膂，络肾属膀胱……因其从头至足，故是人体最大最长的经脉。太阳经行于背，背为阳之府，太阳经行于阳道；督脉又为阳经之总督，而太阳经上连于督脉的风府与督脉并行，故太阳为诸阳主气，为阳经之长。

太阳之腑为膀胱。《素问·灵兰秘典论》说：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”说明膀胱有主藏津液和气化的功能。然而膀胱的气化，必须借助于肾气的支持，而肾主水的功能，又与膀胱水腑的气化开阖作用息息相关，由于太阳与少阴阴阳会通，脏腑经脉相连，故相为表里，而互相为用。

肾与膀胱的关系，主要体现在对水液气化功能方面。何谓气化？张介宾说：“津液入为水，水之化者为气，有化而入，而后又出，是谓气化则能出矣。”说明气化是由气以化水，气以行水，也就是说，水的变化在于阳气的作用。

太阳之腑在于里，它有藏津液的作用；太阳之经居于外，它有主表的作用。太阳主表的功能，也与气化的功能有关。因太阳之气，依赖于肾中元阳之气的资助，而肾阳资始之气通过太阳行于体表叫做卫气。卫气之行：古人认为一日一夜五十周于身，昼行于阳二十五周，夜行于阴二十五周。平旦阴气尽，阳气出于目，目张则气上行于头，循项而下太阳。因此，起到主表的作用。太阳，巨阳之义，其阳不巨，则不足以密腠理而抵御外邪。故太阳为六经之首，总统营卫，肥腠理，温肌肉而司开合。《灵枢·营卫生会》说：“太阳主外”，又说：“卫出于下焦”，足以

说明太阳主表而与少阴的关系是分不开的。

所谓“卫气”，也可以说是阳气和津液相互作用而生成的。人体津液的输布，无不由于阳气的蒸化与流布。《灵枢·五癃津液别》说：“故三焦出气，以温肌肉，充皮肤为其津；其流而不行者为液。”可见气行则津布，津布则皮毛肌肉才能得到温养。故《灵枢·本藏》说：“肾合三焦膀胱，三焦膀胱者，腠理毫毛其应。”这就具体反映了卫气卫外固表的作用是和少阴水脏、太阳水腑、三焦水道的气化功能协同作用分不开的。

卫气虽然来于肾，起于下焦，但又必须藉赖中焦水谷之气的不断补充，使其生化不息。《灵枢·营卫生会》所说：“人受气于谷，谷入于胃，以传与肺，五脏六腑皆以受气，其清者为营，浊者为卫”，正揭示了卫气虽发源于下焦，但资助补充则在于中焦，而开发宣布则在于上焦。所以《灵枢·决气》说：“上焦开发，宣五谷味，熏肤充身泽毛，若雾露之溉，是谓气。”这就不难看出，上焦肺气的呼吸开发也是太阳主表，发挥卫外为固作用的一个必不可少的条件。

太阳的病变特点：

太阳病，可分经证与腑证两类。但由于经与腑相连，故在病理变化上，又常互相影响而发病。若外邪初犯体表，正邪斗争在体表的部位，使太阳经气不利，阳气被郁，气机失宣而出现营卫不和等证，则称之为太阳表证，或叫太阳经证；若表邪不解，随经入腑，热与血结，或气不化水，又可形成太阳腑证。

太阳经脉行于头项，太阳受邪，经脉不利，则见“头项强痛”；阳气受伤，温煦失职，则见恶寒；邪在表，气血抗邪于外，则其脉必浮。太阳表病，由于感受风邪或寒邪的不同，而又分为“中风”与“伤寒”两类不同证候。

《素问·五藏生成》说：“肺之合皮也，其荣毛也。”凡表受邪侵，则皮毛不利，玄府失调，以致肺失宣降，则可发生咳嗽、气喘等证。人体表里相通，故邪客于表，使里气不和而上逆，可兼见胃失和降的呕吐等证。

太阳与少阴，经脉相连，互为表里。若其人少阴阳气先拔，则太阳感寒以后极易内陷少阴之脏，而出现脉微细，但欲寐，厥逆和下利清谷等证；若太阳之邪不解，而少阴里证已见，如太阳头痛发热反见少阴沉脉，则叫太阳、少阴“两感”之证。因此证已内涉少阴，故带有险情，实不可轻视。凡太阳病而内累及少阴的，多与少阴阳虚有关。许叔微曾说：“伤寒不拘阴证阳证，阴毒阳毒，要之真气强壮者易治，真气不

守，受邪才重，便有必死之道。”俗语说：“伤寒多死下虚人”，就足以说明少阴阳虚伤寒的严重性。

膀胱者，州都之官，主藏津液，为水之腑，有气化之权。若太阳在经之邪不解而随经内犯入腑，或由于膀胱自身的气寒水凝，气不行水，水不化气，则可发生膀胱蓄水之证。

太阳经邪循经入腑，若不与水结而与血结，其部位不在膀胱而在小肠者，则叫太阳蓄血证。太阳蓄水与太阳蓄血统称为“太阳腑证”。

太阳病为外感病的初期阶段，若邪向里传，首先则侵犯胸部，因为胸位邻近体表，即所谓“表邪入里必先胸”的意思。表邪化热蕴郁胸膈，若未与有形之邪相结，则为“虚烦”证；若与胸膈乃至脘腹痰水相结者，则为“结胸”证。若表证误治，损伤脾胃之气，使中焦升降功能失调，加之痰、水、食滞等邪气的干扰，发生以胃脘痞塞为主的证候，则为“心下痞”。

“太阳病篇”还收入了其他因于误治而后发生的脏腑虚实寒热的种种“变证”，对这些“变证”的辨证论治，则有辨杂病的意义，它补充了六经辨证的不足，因此具有广泛的意义。

在治疗方面，太阳病以经表之证为主，“太阳篇”则重点讲了汗法。根据表证的不同类型，可分别选用桂枝汤、麻黄汤、大青龙汤、小青龙汤、葛根汤等不同的发汗方剂；或桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤等小汗方剂。太阳腑证，蓄水的则以五苓散通阳利水；蓄血的则可分别选用桃核承气汤、抵挡汤、抵挡丸等以泄热破结，逐血化瘀。太少两感或少阴伤寒，则用麻黄附子细辛汤、麻黄附子甘草汤温经发汗，或服药不瘥，则用四逆汤急温少阴之里。“虚烦”证，宜用栀子豉汤清热除烦；“结胸”证，则宜以大陷胸汤、丸泄热逐水或以小陷胸汤清热涤痰。“心下痞”证，可根据不同类型分别使用半夏泻心汤等一类方剂辛开苦降，和中消痞。至于对诸“变证”的治疗，则应按“观其脉证，知犯何逆，随证治之”的原则进行处理。

本书依原书篇章，将《辨太阳病脉证并治法》仍分为上、中、下三篇。上篇部分主要论述了太阳病脉证总纲、太阳表证分类的脉证提纲等，可谓“太阳病篇”的总论部分。还论述了太阳表证的类型之一太阳病中风的证治，以及有关桂枝汤的加减禁忌证。其中辨病发阴阳与真假寒热，则对全书的辨证具有指导意义。

太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。（1）

【解析】本条为太阳病脉证总纲。

太阳为六经之首，主表而统营卫，为一身之外藩。故外邪伤人，太阳首当其冲，正邪交争于体表，而出现表病的脉证。本条之所以为太阳病的总纲，正是因它指出了表病脉证的共性。“脉浮”为表病主脉，放在诸证之前，可见其对诊断表证所具有的重要性。邪犯体表，营卫气血必抗邪于表而充盈于外，脉为气血之先，故脉外应而浮。李濒湖说：“浮脉为阳表病居”，因此，“有一分浮脉就有一分表证”。临诊不论何病，也不论病程之长短，凡见浮脉，即当首先考虑表证之存在。“头项强痛”为太阳病主证。头为诸阳之会，是三阳经之通位。但诸阳经依其循行部位之不同，又各有所主。而头项部则为太阳经脉所过，故项为太阳之专位。太阳经脉受邪，气血涩滞，经脉拘急，于是就出现头项疼痛，活动不能自如的“项强”证候。恶寒，是表证的重要表现。在“恶寒”之前用一个“而”字，有“而且一定”之意，以示强调“恶寒”对辨证的重要性。邪伤太阳之气，卫气失掉正常的卫外功能，所以病人感到怕冷。表证恶寒，是因太阳之气受伤，临床多见背恶寒较甚，且以下午恶寒较重为特点。因邪客于表卫阳先伤，午后而阴寒得逞，所以会有这一现象。

太阳被外邪所伤，见证莫确于脉浮、头项强痛与恶寒三证，凡见此脉证，即可诊断为太阳病。但外邪束表，阳气闭郁，还会出现发热。本条不提发热一证，可能因其较恶寒出现为晚。论中有“或已发热，或未发热，必恶寒”之句，则提示发热一证有迟早，但恶寒则是必然要出现的。本条若是作为太阳表证的提纲，应把发热一证补充进去。此后，凡论中提及“太阳病”时，则意味着“脉浮，头项强痛，而恶寒”，以及发热等脉证已在其内。

本条讲的是太阳表病的共同脉证。由于感邪有不同，体质有差异，临床表现又有不同的类型，故太阳表病可概括为中风与伤寒两类。下面就分别讨论各个不同类型的脉证特点。

太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。（2）

【解析】本条是太阳中风证的脉证提纲。

“中风”，即感受风邪而发生的病证，和今之属脑病范围的猝然昏倒、不省人事、口眼喎斜的“中风”，名同而病异，不可混淆。在太阳病脉证的基础上，凡兼见发热、汗出、恶风、脉缓的，就叫太阳中风证。中风为风邪所伤。风为阳邪，伤人较浅，病位在卫在表。风阳之邪伤了卫阳之气，卫阳与之相争，两阳相并，“发热”一证常先见，而且突出，故本条把发热列在诸证之首。“汗出”证是因卫阳被风邪所伤，卫不固营，又因风性开泄，使营阴不能内守，于是营阴外泄而为汗，汗出则营阴越伤。由于发热与汗出并见，故扪之肌肤多是热而潮润，而非干热灼

手。“恶风”即指恶风寒而言，有风则怕冷明显，无风则怕冷减轻。恶风是因风伤卫阳，汗出肌疏之故。“脉缓”，指脉搏柔弱弛缓，与紧脉相对而言，在“太阳病”前提下见缓脉，即指浮缓之脉。脉浮为邪在表，脉缓为汗出营弱的反映。除上述证候外，还应包括太阳病总纲中“头项强痛”一证。

从临床观察所见，太阳中风患者，每每先觉翕翕而热，随之则汗出，由于汗出肌疏，继而又有洒淅恶风之感。可见本条所列发热、汗出、恶风三证的先后顺序是符合临床实际情况的。

太阳中风证，也称太阳病表虚证，所以称其为表虚，是因汗出伤营，营阴内弱，与太阳伤寒表闭营郁之表实证相对而言，切勿与内伤“表气虚”之黄芪证相提并论。

太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。（3）

【解析】本条为太阳伤寒证的脉证提纲。

在太阳病提纲脉证的基础上，若恶寒之证突出而或已发热、抑或尚未发热，此时身体疼痛、呕逆、脉来阴阳皆浮而紧的，则为太阳病伤寒证。

“必恶寒”，强调了恶寒的必然先见。寒邪客表，寒为阴邪，其性凛冽，比风邪伤人为重而且深，也最易伤人阳气。卫阳被伤，肌表失其温煦，故恶寒必见，而且虽身居密室，复被向火，也不能减轻。寒性凝敛，表闭无汗，卫阳必郁。待阳气闭郁到一定程度，方表现为发热，故伤寒之发热就不如中风之迅速。但也有素体阳盛，感寒发病立即出现发热的，所以用“或已发热，或未发热”这种未定之词，以示发热有早有晚。伤寒发热缘于表闭阳郁，故以干热灼手而无汗为特点，这与中风证发热肌肤潮润而有汗迥然不同。“体痛”即周身疼痛，是太阳伤寒主证之一。寒性凝涩，伤人可外闭卫阳而内郁营血，使营卫气血涩滞不利，故周身疼痛特别明显，《内经》谓“寒主痛”正是此证之机。“呕逆”，是寒邪束表，里气上争，胃气上逆的反映；若寒邪影响肺气不利时，还可兼见喘咳等证。“脉阴阳俱紧”是指寸关尺三部之脉都见浮紧，“脉阴阳”是指尺、寸之脉。脉浮主邪在表，脉紧主寒、主痛、主邪气实。伤寒表实无汗，卫闭营郁，所以表现为脉浮而紧张有力，与太阳中风汗出营弱的浮缓脉不同。太阳病伤寒证，若寸关紧而尺脉迟，或寸关紧而尺脉弱的，则为伤寒夹虚之证，治当另作别论，不可发汗。

太阳中风与太阳伤寒是两种不同类型的表证。中风为风阳伤卫阳，卫外失司，营阴外泄，故以发热、汗出、恶风、脉浮缓为主证，属太阳

病表虚证。伤寒为寒邪直透营卫，卫闭营郁而见恶寒、发热、无汗、体痛、呕逆或喘、脉浮紧等证，属太阳病表实证。其中有汗与无汗则是两证鉴别的要点。

伤寒一日，太阳受之，脉若静者为不传；颇欲吐，若燥烦，脉数急者，为传也。（4）

伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。（5）

【解析】这两条通过对脉证的分析，来辨别疾病的传变与否，使医者懂得如何了解病情发展的趋势，掌握防治疾病的主动权。

“伤寒”在此泛指太阳病，包括中风与伤寒在内。“伤寒一日，太阳受之”，是指外邪初犯体表，太阳首先受邪，欲知其病情是否传变，则应以脉证作为判断依据。其人“脉若静”，即指脉不数不急，原浮脉不变，反映太阳之邪仍在表，没有传变的迹象。亦可体会为“脉静”是正复邪却，邪气不能干扰正气，表邪将解，有自愈机转的倾向。二者均说明正气抗邪有力，邪气尚未传里，所以说“为不传”。“脉数急”与“脉静”相对而言，脉由平静变为数急，反映邪气有化热入里之势。“颇欲吐”，指病人有恶心很想吐的证候。由于少阳病有心烦喜呕的特点，故“颇欲吐”一证在此多代表邪传少阳的征象。“燥烦”，赵本作“躁烦”，是阳热内盛之证，在此则代表阳明之里已有邪热。“欲吐”与“躁烦”，均非太阳本证，乃是太阳之邪向里传变，或传少阳或传阳明的表现，而反映在脉上，又有“数急”的变化，所以说太阳病有了传经的趋向。

“伤寒二三日”与“伤寒一日”，乃相对而言，指非太阳发病之初始。尽管太阳病已有二三天，但在临床表现上既无“燥烦”等阳明证可见，也无“颇欲吐”等少阳证出现，所以说“为不传”。

由此看来，伤寒一日有传者，伤寒二三日也有不传者，欲知其是否传变，主要应以脉证的变化为准，不可拘泥于发病的日数。伤寒外感热病，因其传变迅速、变化多端，故古人有“走马看伤寒”之说。医者应随时密切观察脉证，紧紧抓住传变的脉证反映，才可防患于未然，掌握治疗疾病的主动权。

太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。（6）

【解析】本条是太阳温病脉证提纲。

太阳表病，无论中风、伤寒，均不应见口渴和不恶寒之证，若见口渴而不恶寒，则标志着邪气已内传阳明。今既见此证，却又称太阳病，则知非为风寒，而属“温病”。温病为温热邪气伤人，温为阳邪，化热疾速而最易伤阴耗液，因此在发病的开始阶段（即卫分阶段），在发热的

同时便出现了津液伤损的“口渴”，这是与伤寒有别的证候之一。由于温热伤人重在耗阴故多不恶寒。但在临床上，温热初犯肺卫之时，也有短暂而轻微的恶寒，此时切不可认为是风寒伤表而误用辛温发汗，以致助热伤阴，贻患无穷。

温病属广义伤寒的范围，本条举出其脉证特点，是作为同狭义伤寒进行鉴别而设的，因为温病属于伤寒类证之一，故临证当注意鉴别。

若发汗已，身灼热者，名曰风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视，失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘵痲；若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。（7）

【解析】本条提出风温脉证，治疗禁忌及误治后的变证，以资与风寒外感证相鉴别。

风温是风阳与温热邪气合并侵犯人体而造成发热的病证，它与风寒束表，阳郁发热的伤寒证完全不同。伤寒用辛温发汗，则汗出邪退热减；风温若用辛温发汗，则风邪虽可去，但温热却反增，致使发热灼手较前更甚，因此风温应禁忌使用汗法。“脉阴阳俱浮”是寸关尺三部脉都见浮象，不言紧，说明与伤寒之脉不同。风与温热都是阳邪，阳邪袭表，气血外应，故脉浮。风性疏泄，热迫营阴外越，故自汗出。温热邪气壅遏，使阳气被郁则见身重，它与伤寒的身疼痛有寒热的不同。热扰心神，精神昏愤，则见多眠睡。心主言，心神被扰，则见语言难出。温热上壅，肺窍不利，则鼻息必鼾。上述一派温热耗气伤阴之证，治当辛凉解热、甘寒滋阴，切忌用辛温发汗，苦寒泻下，以及火疗劫汗等法，否则将变证丛生。若误下重伤阴液，则小便短少而不利；肝肾阴伤，阴精不能上荣于目则直视不眴；关门不固，则二便失禁。若误用温针、熏熨等火攻劫汗，火热之邪加于温热，熏灼肝胆，轻则身发黄色，重则火邪内攻，心神失守，发如惊痫之状，或引动肝风而见时时抽搐。若误火之后，又以火熏法取汗，更是一误再误。一误尚有图治之机，再误则促人以速死，切不可不慎。

本条列举风温脉证，以便与风寒之证鉴别。其中误火之各种变逆，实际也可以看成是温病不同阶段的临床表现，以示温热之邪伤阴与风寒之邪伤阳的证候迥然不同。

病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳者七日愈，发于阴者六日愈。以阳数七，阴数六故也。（8）

【解析】本条以寒热的不同证情，辨病发于阴或发于阳，有以阴阳两纲来统摄六经辨证的重要意义。

“阳”指阳证，阳经的病证；“阴”指阴证，阴经的病证。正被邪伤则恶寒，阳与邪争则发热，既有发热，则知正气不衰，阳气尚旺，抗邪有力，故多属阳经之证，即阳证。三阳经病，阳气皆盛，故均以发热为主。太阳有发热恶寒，少阳有往来寒热，阳明有蒸蒸发热、日晡潮热。故凡以发热为主者，多属阳证，即“发于阳也”。无热恶寒，则是阳虚阴盛，正气虚衰的表现，因此多属三阴经病，即阴证。如三阴病，常见恶寒、厥逆而不发热，正是“发于阴”的征象。

治病当察色按脉，先别阴阳。而本条以最明显的寒热二证来辨阴阳，实有提纲挈领之妙。六经辨证，虽一言难尽，但只此一句，便高度概括了三阴三阳为病的证候特点。因此，后世医家认为此条应“冠于六经之首”，是很有道理的。《外台秘要》载：“发于阳者，可攻其外；发于阴者，宜温其内。发表以桂枝，温里宜四逆”，指出了本条证候的治法，可作参考。有的注家认为太阳病中风叫病发于阳，伤寒则叫病发于阴，未免有些局限。

至于文中后半段“六日愈”、“七日愈”之说，仅是对疾病预后的推测。阳数七，阴数六是根据伏羲的河图“水火成数”、“阴阳奇偶”等推算而来。河图记载“天一生水，地六成之”，“地二生火，天七成之”，因此，阴、水成数为六（偶数），阳、火成数为七（奇数）。水的成数是六，水属阴，故阴数六；火的成数是七，火属阳，故阳数七。病为阳证，当在阳数之期愈，故云“七日愈”；病为阴证，当在阴数之期愈，故云“六日愈”，其说的科学意义，还有待进一步研究。

太阳病，头痛至七日已上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。（9）

【解析】本条论太阳病自愈的道理以及预防传经的方法。

头项强痛是太阳病的主证之一，其轻重有无，可作为判断太阳病进退的一个标志。“太阳病，头痛至七日已上自愈者，以行其经尽故也”，意思是说：太阳病有不药而自愈的机转，并指出其原因是，经过七日以后，太阳本经的邪气已经衰退，无力以传。“行其经尽”，即指邪在太阳经的势力已尽，并始终未传他经。古人有七日正气来复的理论，可能是“七日已上自愈”的原因之一。

若七日以上没有自愈，说明太阳之邪不衰，病情将要向里发展而发生传经之变，这叫“欲作再经”。其预防与治疗传经的方法是：“针足阳明”，迎而夺之，以泄太阳传来之邪，消减邪气内传之势。同时，“针足阳明”还可振奋阳明胃气，而有补气血、扶正气的作用。古人说：“正气存内，邪不可干”，这样则可达到“使经不传则愈”的目的。据一些医家

意见及临床报道，所谓“针足阳明”，即可取该经的足三里穴。从日本报道的灸足三里以使老年人却病延年的例子，亦可以看出，“针足阳明”对健身防病确有其临床价值。

太阳病，欲解时，从巳至未上。（10）

【解析】本条运用人与自然的协调统一、相互感应的关系，以推测太阳病欲解的有利时间。

本条的大意是：太阳病如果邪气解除而欲愈的话，其时间当在白天的巳时至未时可能性最大。为什么这样说呢？因人与自然密切相关，人体内环境昼夜、四时的变化，无不受自然界昼夜、四时变化的影响。巳至未时指上午九点至下午三点前的一段时间，这是一天中自然界阳气旺盛的时候，《内经》称之为“阳中之太阳”，“太阳乘王”之时。人体由于受自然界阴阳盛衰变化的影响，所以太阳经的阳气此时也最旺盛，从而为正复邪退创造了最有利的条件，故太阳病欲愈，在此时间内的可能性最大。六经病证各有相应的欲解时，但其临床实际价值及意义，尚有待进一步研究、探讨。

风家，表解而不了了者，十二日愈。（11）

【解析】此条指出，在太阳病表邪已解而正气未复的情况下，应待其自愈。

“风家”，在此泛指易患太阳表病的人，这些人大多体质较弱。“不了了”即精神与身体还不爽快，病好的不彻底。患太阳表病的人，表证已解，大邪已去，但正气未复，因此尚有一些不爽快、不舒适之感，如身体酸楚，或欠或嚏等。此时不必再用攻邪之药，应嘱病人将息调养，十多天左右即可自愈。所谓“十二日愈”，只是约数，不必深究。

病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。（12）

【解析】本条通过病人的喜恶，来辨病证寒热的真伪。

第8条以寒热辨病发阴阳是辨证的总纲，在一般情况下是适宜的，但在表象与本质不一致的情况下，则应透过寒热的现象去探求疾病的本质。“皮肤”指人体表浅部位，在此引申为疾病的表象。“骨髓”指人体内里部位，在此引申为疾病的本质。病人虽周身大热，但反而想加衣覆被以御寒，说明“大热”是表面现象或者说是假象，而寒邪在内，才是疾病的本质。这种病证多见于阴寒盛于里，虚阳格于外的“阴盛格阳证”，是为真寒假热，即“热在皮肤，寒在骨髓”的病机。

病人周身虽冷，但又不愿加衣被而就温，说明“大寒”也是表面现

象，是假象，而热邪在内才是疾病的本质。这见于阳热深伏，郁闭于里，阻阴于外的“热深厥深”之证，是为真热假寒证，即“寒在皮肤，热在骨髓”的病机。

阴阳互根，二者之间互相维系，互相制约，才能发挥正常的生理功能。若一方盛极，则可能将另一方排斥于外，或逼迫于上。若阴盛排阳于外者，则为“格阳”；逼于上者，则为“戴阳”。“格阳”与“戴阳”都是阴阳相离之危证，故临证时一定要注意透过现象看其本质，方不致犯实实、虚虚之诫。然辨本质的关键，此条指出在于察病人的“欲”与“不欲”。“欲”与“不欲”是病人的主观愿望，常常也是疾病本质的反映，辨证时必须重视。但临床还应综合全面情况，即四诊合参，才能切实做到去伪存真。如真寒假热的面赤如妆、咽干不欲饮、小便清长、舌淡嫩、脉浮大虚数无根，真热假寒的口渴喜冷饮、小便短赤、舌红、脉数等脉证，均有重要的辨证意义。

太阳中风，阳浮而阴弱。阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出。啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。（13）

桂枝汤方：

桂枝三两，去皮 芍药三两 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上五味，**㕮**咀。赵本有“三味”二字以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾，**㕮**热稀粥一升余，以助药力，温复令一时许，遍身**𦛳𦛳**，微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂；若不汗，更服，依前法；又不汗，后服小促役其间，半日许，令三服尽；若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服；若汗不出者，乃服至二三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

【解析】本条补充了太阳中风证的脉证并提出治法。

“阳浮而阴弱”，既指脉象，也言病机。从脉象来讲，阳指浮取，阴指沉取。风伤卫，表有邪，故其脉轻取见浮；自汗出，为营阴伤，故其脉沉取弛缓而见弱，这正是中风证典型的浮缓脉象。从病机来讲，风阳之邪伤于表，卫阳之气抗邪而盛于外，则发热在所难免，故曰“阳浮者热自发”；卫不固营，风性疏泄，使营阴外泄而为汗出，汗出则营阴更弱，故曰“阴弱者汗自出”。“啬啬恶寒”，形容恶风寒怯弱畏缩之

貌；“淅淅恶风”，形容恶风寒如凛风冷雨骤然吹淋其身之状，此皆为风邪伤卫，卫外功能失调的表现。“翕翕发热”，形容热在浅表有如着衣覆被之热，故为表热的特征，与里热内出之蒸蒸发热不同。肺主气，外合皮毛，开窍于鼻，风邪外束而上壅，致肺气不利，则鼻道塞而时通，故作鼻鸣，并常伴流清涕、不辨香臭等证。若表气不和，影响及胃，里气上争，胃气上逆，则又可见“干呕”之证。鼻鸣、干呕只是太阳中风的或见证，而本条所列举之发热、自汗、畏恶风寒、脉浮缓，才是太阳中风的主要脉证。

太阳中风当治以桂枝汤。所谓“主之”即此证对此方，信任施用，不须顾虑，有非此方不可之意。

桂枝汤由五味药组成。桂枝与芍药应等量，若桂枝量大于芍药，则名桂枝加桂汤；若芍药量大于桂枝，则名桂枝加芍药汤，三方主治各不相同，故用药剂量当审慎，不可违其用药之宗旨。

方中桂枝辛甘发散，解肌祛风，温通卫阳，以解卫分之邪。芍药酸苦微寒，滋阴和营，以固护营阴。二药相伍，于发汗之中有敛汗之旨，于和营之中又有调卫之功。生姜辛温，佐桂枝发散风寒以解肌。大枣甘平，据《神农本草经》载，有“安中养脾”、“补少气、少津，身中不足”的功能，在方中它能佐芍药补津液而养营阴。甘草甘平，调阴阳，和中州，安内以攘外。配桂姜辛甘合化为阳以助卫气；配芍枣，甘酸合化为阴以滋荣阴。五药配合，则具解肌祛风，调和营卫，发汗止汗，发汗而不伤正，止汗而不留邪的功效。

方中桂、姜、枣、草均为食品中之调料，有开胃口，增食欲，健胃气的作用。因此，桂枝汤确有调和脾胃之功，而且通过调和脾胃以达到滋化源、调气血、和阴阳、调荣卫的作用。可见本方在外可解肌祛风、调和营卫，在内可调和脾胃、气血、阴阳，所以无论外感、内伤均可应用。如其可治外感所致之营卫不和，亦可疗内伤所致之营卫失调；加芍药、饴糖可温中补虚和里缓急，治虚劳腹痛；加龙骨、牡蛎，可交通心肾、交通阴阳，治男子失精，女子梦交；又如加葛根、加厚朴杏子、加人参、加附子、加芍药、加桂枝、加大黄，以及去桂枝、去芍药等等，略予加减，则不仅可以治疗太阳中风的许多兼证，而且又可主治他经的一些病变，可以说是左右逢源，使用范围极广。

凡病不外阴阳失调。其治疗原则，总是察阴阳所在而调之，以平为期。本方滋阴和阳，调和营卫气血，合法度、守原则，无愧仲景将其列于众方之首，柯韵伯称之为“群方之魁”，这既体现了作者治病从调和阴阳着手的学术思想，也体现了作者伤寒与杂病同论而不可截然分开的学

术观点。

方后所注之煎服法及禁忌甚详，也至为重要。本着详于前略于后的原则，对以后诸方的煎服法均有一定的参考价值。

“**咬**”，是用牙咬碎；“**咀**”，是品尝滋味。“**咬咀**”在此指将药破碎，以便于煎出有效成分。煎药当用微火，以水七升，煎取三升，去药渣，每次温服一升。服药后要大口喝热稀粥一碗，一则可借谷气充汗源，一则可借热力鼓舞卫阳驱邪从汗解，此即所谓“助药力”之法。然后覆被静候待汗。发汗的要求是：以“遍身**𦵏𦵏**”，微似有汗者益佳，不可令如水流漓。”**𦵏𦵏**，汗出貌。似，嗣字之假借，续也。就是说发汗要发小汗，汗出要周遍和持续，这样才能达到祛邪的目的。若发大汗，使病人汗出如水流漓，则邪不出而正气伤，故谓“病必不除”。若一服汗出病解则不需再服药。若不汗出，依上法服第二次药。仍不汗，缩短间隔时间再服第三次，在半天内服完三次药。病重者，还可日夜连续用药，随时观察。一剂服完，病证未去，还可再服，直至服二三剂也没有什么不可。所忌食物，则多属生冷、油腻、不易消化或对胃有刺激的食品，因其伤害胃气，有损清阳之气故列为禁忌。这也反映了张仲景在临床治疗的各个环节均重视“保胃气”的学术见解。

太阳病，头痛发热，汗出恶风者，桂枝汤主之。（14）

【解析】本条进一步扩大了桂枝汤的治疗范围。

文中冠以“太阳病”是泛指一切表病，无论中风、伤寒、已治、未治，甚或其他表证，只要见到头痛发热，汗出恶风，便是桂枝汤的适应证，即可使用桂枝汤。这样就使桂枝汤的使用范围不仅仅局限于太阳中风一证，而可以更加广泛地应用。但必须坚持辨证论治的基本原则，有是证，才能用是方。

如曾治一老年，久患荨麻疹，周身苦痒，影响睡眠。曾服凉血、清热、疏风、燥湿、解毒之药多剂，未见功效。诊其脉浮而缓，问其证，除身痒之外，还有怕风，发热，出汗等证。遂用桂枝汤原方，嘱药后啜热粥，温覆取汗。果然药后汗出疹退，脱落皮屑甚多，从此而愈。

柯韵伯说：“此条是桂枝本证，辨症为主，合此症即用此汤，不必问其为伤寒、中风、杂病也。”是深得仲景旨意之谈。他常以此汤治自汗、盗汗、虚症、虚痢等病而见上述证候者，则每每“随手而愈”。

太阳病，项背强**几几**，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。（15）

桂枝加葛根汤方：

葛根四两 芍药三两 甘草二两 生姜三两，切 大枣十二枚，擘 桂枝二两，去皮 麻黄三两，去节

上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，复取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法。

【解析】本条论述太阳中风，经输不利的证治。

几几，本为短羽之鸟伸颈欲飞而不能起的样子，在此形容病人项背拘急，俯仰不能自如。或指病人项背拘急，似水鳃游水，其颈直伸不动的一种姿态。项背强几几，较太阳病头项强痛证的病位范围为大，从头项延及项背。此证多因寒邪侵犯太阳经脉，寒主凝滞收引，使气血为之不畅，筋脉肌肉拘急而致，但必有无汗、恶寒等证并见。而今反见汗出、恶风，知在经之邪非寒而为风，风邪在经，经输不利，津液不能上濡，所以项背拘急，俯仰不能自如，治以桂枝加葛根汤。本方用桂枝汤解肌祛风，滋阴和阳，加葛根作用有三：一则升阳发表，解肌祛风，助桂枝汤以解表；二则舒筋通络，解经脉气血之凝滞；三则凡经脉拘急，多有津液不滋的因素，葛根甘寒生津，起阴气，鼓舞阳明津液布达，滋润燥，以缓解经脉之拘挛。现市售愈风宁心片，即为葛根制剂，对高血压患者兼有项背强硬酸楚不适感的，效果很好，可能就是这个道理。

曾治一女病人，患颞颌关节炎，口不能开，饮食困难。他证尚有口渴、心烦、脉来弦长等。考虑病位为阳明胃经所过（足阳明经脉环口而至承浆），遂用石膏30克、葛根18克，并略加他药。服用三剂后，其口即可张开，连服六剂则痊愈。正是取葛根通经络、升津液之意。

本方原书中有麻黄，宋林亿校正此书时认为，加麻黄为误，当去之。

太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤。方用前法。若不上冲者，不可与之。（16）

【解析】本条论述太阳病误下后，应根据正气抗邪的能力及表证存在与否而决定治法。

太阳病，当用汗法，若误下，则表邪不解徒伤里气，往往有使邪气乘虚内陷，造成坏病的危险。如后文指出的“太阳病，脉浮而动数……表未解也，医反下之……阳气内陷，心下因鞕，则为结胸。”即是误下后邪气内陷之变。也有虽经误下，但正气不衰，太阳之气仍可向上向外

抵御邪气，使疾病维持在表证阶段的情况。这与“内陷”相对比，便叫“其气上冲”。“其气”，指的是太阳之气。“上冲”，指的是阳气没有内陷。

太阳病，无论中风、伤寒，经误下后，虽“其气上冲”，邪未内陷，表证仍在，但毕竟正气受挫，故不可用麻黄汤发汗而应以桂枝汤治疗。“可与桂枝汤”与“桂枝汤主之”用词不同，意义也不同。“主之”是信任施用。“可与”则有斟酌考虑之意。因误下后证情变化较多，故不能在治法与方药上说得太肯定。但如仍需服用桂枝汤，其服法则仍应如前。

若不上冲，说明太阳之气已不能抗邪于表，表证不复存在，自然也不应再与桂枝汤了，故曰“不可与之”。

太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病。桂枝不中与也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。（17）

【解析】本条指出了表证误治后发生“坏病”的治疗原则。

“太阳病三日，已发汗”，是说太阳病当汗，但发汗不得法，故虽经发汗但病不除。“若吐，若下，若温针”是说太阳病不当用吐、下、温针等治法，而反用了这些治法。“温针”是古代较为盛行的一种治疗方法，即针刺后在针柄以艾火加温，使温热从穴位透入，以达到治疗目的，多用于治疗痹证及内寒疼痛等证。本条由于治不得法或治疗上的错误，以致病“仍不解”。从“桂枝不中与也”提法上看，可知这个“仍不解者”非为太阳表证不解，而是病情发生了新的变化，或者说是被治坏了的病，故张仲景称之为“坏病”。所提出的“观其脉证，知犯何逆，随证治之”的救治法则，即要求医生对“坏病”应仔细、谨慎地审查其现有的脉证，了解分析各种误治原因及所造成的后果，然后顺随客观病情，恰如其分地进行辨证治疗。这一观点，不仅对治疗坏病有指导意义，而且对治疗其他各种疾病，都有普遍的指导意义。因为这一法则的基本精神就是辨证论治。

桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与也。常须识此，勿令误也。（18）

【解析】本条指出，太阳伤寒表实证忌用桂枝汤。

“桂枝本为解肌”，提示桂枝汤之解肌发汗和麻黄汤之发汗解表不同。桂枝汤仅仅是解肌而已，发汗力弱，又有芍药、大枣之酸敛甘补，于发汗之中有止汗之意。而“脉浮紧，发热汗不出者”，为寒邪闭表之太阳伤寒表实证，应用麻黄汤发汗解表，开泄腠理，发散寒邪。桂枝汤无开表闭之力，反有敛荣止汗之弊，所以说“不可与也”。如误用之，可使

表闭阳郁更甚而使病情加重，以致转成不汗出而烦躁的大青龙汤证或发生斑、黄、狂乱等种种变证。正因为误用桂枝汤所造成的后果是严重的，故张仲景反复叮咛：“常须识此，勿令误也。”“识”，读“志”，牢记之意。即一定要常常牢记此言，不要误用桂枝汤去治疗伤寒表实证，这样才不至于发生错误。

太阳伤寒表实证忌用桂枝汤，这是应该注意的一个方面。反之，中风表虚证也要忌用麻黄汤，误用则可造成大汗不止而发生伤阳耗阴之变，“一隅三反”，这一点也千万不能忽视。

若酒客病，不可与桂枝汤，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。

(19)

【解析】本条通过酒客病忌用桂枝汤，提示凡内有湿热者，用桂枝汤都应审慎。

“酒客”，为平素嗜酒之人，多是酒湿内留，郁久化热，以致湿热稽留中焦，见舌质胖而紫暗，舌苔黄腻，鼻头红赤等证。“酒客病”，有两种解释：一为酒客患太阳中风，由于外有风邪，内有湿热，故虽可用桂枝汤解肌祛风，但当去甘草、大枣之甘温补腻，加葛花、枳椇子等清解酒湿之品。若单用桂枝汤，则因其为甘温之药，助湿增热，使中焦湿热益甚，以致胃气上逆而呕吐。一谓“酒客病”乃中风之类证，非酒客患中风。过嗜酒醴，湿热内蕴，导致气血失调，营卫不和，而见头痛、身热、汗出、恶心、呕吐等证。证类外感，实非外感。治当清热化湿，理脾和中。若误诊为中风而用桂枝汤，则因甘可助湿，温可增热，正如火上加油，亦必然加重病情而出现胃气上逆之呕吐。以上两种情况，均不适于用桂枝汤，责其原因只有一个，即“酒客不喜甘故也”。

从酒客病不可与桂枝汤引申推广，可以说凡素体湿热内盛者，使用桂枝汤时都应谨慎。

喘家作桂枝汤，加厚朴杏子佳。(20)

桂枝加厚朴杏子汤方：

于桂枝汤方内，加厚朴二两，杏仁五十个，去皮尖，余依前法。

【解析】本条论述太阳中风兼喘的证治。

“喘家”为素有喘病之人。“作桂枝汤”，意指病人新感太阳中风，应使用桂枝汤。素有喘病，复有新感，风邪外袭上壅，影响肺气不利，故

使喘病发作加重。此时当以治疗新感为主，用桂枝汤解肌祛风，同时加厚朴、杏仁降气利肺兼以治喘。这样加味治疗比单纯使用桂枝汤效果好，故曰“加厚朴杏子佳”。用药之后，新感可解，宿疾则不可能根治，故不说“主之”而曰“佳”。

在临床上，因风邪致喘者并非少见。此证本应使用桂枝加厚朴杏子汤治疗，但误用麻杏石甘汤者却屡见不鲜。麻杏石甘汤用于肺热作喘甚效，桂枝加厚朴杏子汤则用于风寒束肺者甚佳，一治肺热，一治风寒，应注意鉴别使用。

凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。（21）

【解析】本条论述热毒蕴结而致内有痈脓的患者，不能用桂枝汤。

从“其后必吐脓血”可知此患者必原有内痈之疾，或为肺痈，或为胃痈，总之素体热毒较盛。因热毒内蕴，正邪斗争，影响气血营卫不和，在外可表现为恶风寒、发热、汗出等类似太阳中风的证候。如审证不确，错认作太阳中风，而误投桂枝汤甘温之剂，则更助其内热，而使病情恶化，出现呕吐等证。继之则热毒腐血成脓，内痈溃破而吐出脓血等物。

综合第19条和本条所述，凡内有湿热或热毒者，无论病在何经何脏，均不可误投桂枝汤，以其甘温助热之故。推而广之，凡温病、风温、湿温等证，也均当忌用桂枝汤，临床不可大意。

太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四支微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。（22）

桂枝加附子汤方：

于桂枝汤方内，加附子一枚，炮，去皮，破八片，余依前法。

【解析】本条论述过汗伤阳而表未解的证治。

太阳病，发汗本是正治之法，今发汗后见漏汗不止，是卫阳不固，汗孔不合之故。造成这种情况的原因，注家认为多见于太阳中风误服麻黄汤，“虚其虚”，以致阳不摄阴，卫不固表；也可见于用桂枝汤汗不得法，温覆太过，以致发汗过多。桂枝汤方后注云“不可令如水流漓，病必不除”，可见漏汗不止，反使在表之邪并不能解除。“汗为阴液”，“阳加于阴谓之汗”，汗是阳气蒸化津液而成。漏汗不止，必伤阳损液而见诸种变证。“其人恶风”，指出恶风寒的程度较原来的中风证恶风寒更重，是过汗伤阳，卫阳不固之故；“小便难”，指排尿不利。《素问·灵兰秘典论》谓：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣”。今过汗伤阳损阴，膀胱津少气冷，化源不足，气化无力，故小便点滴不畅；“四支微急，难以屈伸”，是指四肢轻度拘急，活动不能自如。四肢为诸阳之本，阳气者，精则养神，柔则养筋。今阳虚液伤，四肢失却阳气之温煦，阴液之滋养，故觉拘急而活动不能自如。综上所述，可知其病原因在于发汗太过；主证是漏汗不止；主要病机是卫阳大伤而阳不摄阴。故其治疗当固阳止汗，调和荣卫，用桂枝加附子汤。为什么大汗后阴阳两伤而治疗却只用补阳药，不用滋阴药？这是因为，阴伤乃由阳虚表不固，以致阴液丢失太多所引起。主要矛盾在于阳虚表不固，扶阳即可以摄阴。且阳生则阴长，阳气恢复，气化功能正常，阴液就可自行恢复，所以不必加滋阴之品。

附子辛甘大热，能温肾助阳，回阳救逆。少阴肾阳得复，则卫阳充实，卫外为固，漏汗自止。气化正常，阴液渐复，则小便自然得以通利。

此证属表阳虚漏汗不止，已接近于亡阳，急当用附子扶阳固表，绝非黄芪、浮小麦、龙骨、牡蛎之类所可止。至于表气虚，肺气不固之自汗，则可使用李东垣补中益气汤、保元汤之类，重用黄芪常可取效，也非本方所宜。后世注家或云本条在表之风邪未去，或云在表之风邪已去。但无论有无表邪，均可使用本方。因桂枝汤既可解肌祛风，也可调和营卫而治表虚。

曾治一女子，汗漏不止，先用黄芪、浮小麦、龙骨、牡蛎等无效，

因其无热象，遂用桂枝加附子汤，药后漏汗得止。有不少医生不敢用附子，实际上此药用之得当，常获奇效，只要认证准确，即可放胆使用，不必过于疑虑。

太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。若微恶寒者，去芍药方中，加附子汤主之。（23）

桂枝去芍药汤方：

于桂枝汤方内，去芍药，余依前法。

桂枝去芍药加附子汤方：

于桂枝汤方内，去芍药，加附子一枚，炮，去皮，破八片，余依前法。

【解析】本条论述误下后胸阳受挫的证治。

太阳误下，是表邪入里的条件。表邪入里，证情变化多端，不可尽数。而本条所要讨论的是误下之后，引发胸满的证治。胸为上气海，乃宗气之所聚。正如陈修园所说：“胸为阳位似天空”，其间宽阔而清静，为心肺的宫城。营为心之气，卫为肺之气，上焦开发宣五谷味，营卫的开发皆自上焦，因此胸部离表最近，邪气由表入里第一站就是胸部。胸满之“满”，应读作“闷”，这样读与病情较贴切。腹部可用“胀满”一词，因自觉胀而确可见到“满”，胸部只能自觉“闷”而不能见到“满”，故“满”字在此应读作“闷”，胸满是表邪误下，挫伤胸阳之气而致，因未及血分，故只满而不痛。“脉促”，促者，速也，迫也。在此并非指数时一止复来的促脉。脉搏的急速，一方面反映邪气由表入胸，人体阳气尚能抗邪，与邪相争；另一方面也反映，胸阳之气抗邪的能力已有所衰减，力不从心，故脉促而按之无力。

此证为表邪误下，胸部虽接近表位，但终非表证。治疗则不能仍守桂枝汤原方，而用桂枝去芍药汤治之。桂枝、生姜、甘草、大枣辛甘发散为阳，既可解表邪，又可补心阳、振胸阳，使陷落的表邪由胸透表而解。去芍药的意义有二：一则芍药酸敛，为阴分之药，用之有碍于胸中阳气的振奋宣畅，不利于胸满的解除。二则芍药酸收，对桂枝辛甘发

散、振奋胸阳的作用，大有掣肘之弊。故去之不用，此即避阴就阳之法。

“若微恶寒者”，指病人有轻度的恶寒，非指脉微而恶寒。这是胸阳不振且又兼阳气不足，为阳虚恶寒之证。故在桂枝去芍药汤温振胸阳的基础上加炮附子，振奋心胸，以补阳气。

在临床上，对胸闷、心悸、咳逆等证，凡属阴寒邪盛，胸阳不振者，用桂枝去芍药汤或再加附子颇有疗效。如冠心病患者，心绞痛夜发较重，多属阳虚阴盛。用本方助阳祛阴，每可取效。但桂枝汤去芍药均辛甘之品，如非阳虚阴盛之证，误用则易劫夺津液，故不可不慎。

太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈也。脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也。面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。（24）

桂枝麻黄各半汤方：

桂枝一两十六铢，去皮 芍药 生姜切 甘草炙 麻黄各一两，去节 大枣四枚，擘 杏仁二十四个，汤浸，去皮尖及两仁者

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。

【解析】本条指出了太阳病日久不愈的三种归转：即自愈，表里阳虚，小邪稽表，以及小汗解表的治法。

伤寒病的病程常以七日为一来复期，今太阳病已八九日，尚未传经，可谓留连日久，因而可能发生以下三种转归：

一是病人有发热恶寒，热多寒少，一日发作两三次，像疟疾一样的表现。这反映表邪不重，太阳抗邪之力占优势。“其人不呕”说明胃气和，饮食佳，邪气未入少阳；“清便欲自可”，指大小便较正常。“欲”，亦可作“续”字解，即大小便连续正常，反映了里气和，邪未入阳明；“脉微缓”是脉见微微和缓之象，远非邪盛脉紧之比。以上脉证，反映了邪气渐退太阳之气已复，表里气和，故为欲愈之兆。

另一种转归是，见“脉微而恶寒”。脉微是少阴阳虚之脉，恶寒为太阳阳气虚衰，有邪传少阴之势。太、少阳气俱虚，表、里阳气皆衰，故云“阴阳俱虚”。表里阳虚，表邪尚在，治当温阳固本为急，可选用芍药

甘草附子汤、四逆汤之类，切不可再用汗、吐、下以伐正气而虚其虚。文中用三个“更”字，说明在此变证出现之前，曾用过汗、吐、下等不适当的治法。

还有一种情况是，见“面有热色”、“身痒”等证。面有热色即发热面红之貌，为太阳小邪不解，阳气郁遏不伸所致。阳气郁遏不得宣泄，小邪稽留于皮肤不解，故见身痒症状。这一症状的出现，是因为未能及时发一点小汗的缘故。“不得小汗出”，非指太阳病发病之初所应使用的常规汗法，而是指太阳病留连日久，小邪不去，当用小汗之法，宜桂枝麻黄各半汤。

本证无汗，也未经发汗，小邪怫郁不解，则非桂枝汤所能解。身痒，但不痛，也无恶风寒之证，则又非麻黄汤之所宜。只有二方合用，且制小其服，方切合病情。桂枝麻黄各半汤方，剂量是各取原桂枝汤、麻黄汤剂量的三分之一，合而同煎。柯韵伯主张一剂桂枝汤，一剂麻黄汤，分而煎之，各取每次服量的一半，合而饮之。本方对于邪少势微，且又有欲出外解之机，以面有热色、身痒为主症者最为适宜。麻黄汤治表实无汗，桂枝汤治表虚有汗，二方合用，又制小其剂，则刚柔相济，从容不迫，既能发小汗以祛邪，又无过汗伤正之弊端。

太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。（25）

【解析】本条论述病重药轻时，针药并用之治法。

太阳中风，本当用桂枝汤。服第一次药，啜粥，温覆取汗。若不汗出，风邪不解，当依前法服第二次药。今服第一次药后，不仅未见汗出病减，反而出现了烦热更重的症状。烦者，热也。“反烦不解”，即反而热势更重。既属太阳中风，桂枝汤本为正治之方，为什么用药后病势反重了呢？这是因为在经之风邪壅盛，而桂枝汤的药力较轻，用药后不仅没有发出汗，反而增加了风邪的势力。这种情况就不能再照原法给药，而应在服药之前，先针刺风池穴与风府穴。此二穴对疏通经脉，发散风邪而有卓效，刺之可开太阳经气之闭塞，泄太阳经中之风邪，以削弱在经邪气的势力。然后再服桂枝汤，啜粥、温覆取汗。本条提出的针药并用之法，可谓法中之法，这对后世治疗疾病采用多种疗法联合使用开辟了途径。

本条论药后不汗出，而下条接述药后大汗出，对比启迪，耐人寻味。

服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法；若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。（26）

桂枝二麻黄一汤方：

桂枝一两十七铢，去皮 芍药一两六铢 麻黄十六铢，去节 生姜一两六铢，切 杏仁十六个，去皮尖 甘草一两二铢，炙 大枣五枚，擘

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升，日再。

【解析】本条论述服桂枝汤大汗出后，出现两种不同情况的证治。

服桂枝汤，发汗应遍身**𦵿𦵿**微似有汗者益佳，不可令如水流漓。而今汗不得法，造成大汗出，病不仅不除，常可使病情发生变化。“脉洪大者”，指脉由浮缓变洪大。脉虽变但证未变，提示太阳中风证仍在。如脉变洪大，证见烦渴，则属大汗后阳明津伤，表热入里无疑。今证不变而脉变，说明此洪大脉乃是药后大汗，阳气仍盛于外，即所谓“其气上冲”的表现。故仍可用桂枝汤，如前法。太阳中风，大汗出，脉洪大，极易使人误用白虎汤。其误就误在只见脉而不见证，失之于片面。而当太阳中风证候未变之时，过早使用白虎剂，常可遏郁太阳风邪而发生坏证。故临证一定要脉证合参，全面掌握病情，才能克服片面性。

还有一种情况是，病人服桂枝汤大汗出后，出现有如发疟疾一样发冷发热，一天发作两次的症状，即所谓“一日再发”。这说明营卫之间尚有小邪未解，但较桂枝麻黄各半汤证的一日二三度发的情况又稍稍轻些，且已经过大汗出之后，故用桂枝二麻黄一汤，调和营卫兼祛小邪，最为适宜。

从本方的组成可以看出，它与桂枝麻黄各半汤的药味相同，只是剂量更轻，取桂枝汤原剂量的十二分之五，麻黄汤原剂量的九分之二。本方调和营卫力大而发汗力更小，对大汗出后微邪不解，用之甚宜。桂枝二麻黄一汤与桂枝麻黄各半汤在临床均可治表有小邪而见烦热、身痒的病证。一般地说，凡有表邪见无汗而身疼痛者，当用麻黄汤发大汗；身不痛而痒者，则不可大汗，而宜用此两方之小汗法。这两个方证，寒热交作，其形似疟，但终非疟疾，然而后世用桂枝治疟的思想却由此发展而来。

下条则讨论服桂枝汤大汗出后的第三种情况。

服桂枝汤，大汗出后，大烦，渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。（27）

白虎加人参汤方：

于白虎汤方内，加人参三两，余依白虎汤法。

【解析】本条论述服桂枝汤，大汗出后，伤津耗气，邪热内传阳明的证治。

太阳中风，服桂枝汤为正治之法，但服汤后，因汗不得法而致大汗出。前条大汗出虽脉变洪大，但证不变，故其治法亦不变，仍用桂枝汤如前法。本条脉变洪大而证见“大烦，渴不解”，则知表证已无，而是大汗后，伤津耗气，胃中干燥，阳邪内陷阳明气分所致。胃热扰心故大烦。气津两伤，气不化津，故口渴至甚而饮水亦不解。里热蒸腾，“阳明脉大”，所以脉见洪大，如兼热盛而气阴两伤，则津气不足，故洪大之脉按之则见芤象。治疗则用白虎汤清阳明气分之热，加人参益气生津以治烦渴。

本条是服桂枝汤助热伤津，以致大汗出而大烦渴，转为阳明里热气阴两伤的白虎加人参汤证。而桂枝加附子汤证，则是因误服麻黄汤大汗出后，以致漏汗不止而阳虚不固。一般说来，用桂枝汤发大汗后多易伤阴；用麻黄汤发大汗后多见亡阳。临床虽不绝对如此，但也应加以注意。

如果我们把初服桂枝汤，不汗出，反烦不解；服桂枝汤，大汗出，脉洪大；和服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解等三条联系起来对比分析，则可以从其所列举的服桂枝汤后出现的多种病情变化，和所提出的辨证关键及不同的处理方法中，体会出张仲景随机应变的辨证论治精神，这是值得我们很好地学习和研究的。

太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可更汗，宜桂枝二越婢一汤方。（28）

桂枝二越婢一汤方：

桂枝去皮 芍药 甘草各十八铢 生姜一两三铢，切 大枣四枚，擘 麻黄十八铢，去节 石膏二十四铢，碎，绵裹

上七味，㕮咀。以水五升，煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。本方当裁为越婢汤、桂枝汤，合饮一升，今合

为一方，桂枝二越婢一。

【解析】本条论述表郁生热轻证的治法。

太阳表证，见发热多而恶寒少，表示寒邪束表日久已有部分化热之势。若全部化热，则必见但热不寒，而反恶热的阳明里热证。今尚有恶寒，故未尽化热。脉微弱是与脉浮紧相比较而言。因寒邪已部分化热，故脉由原来的浮紧也随之变为缓弱之象，或者说不那么紧张有力了。“此无阳也”，成无己在对第161条“无阳则阴独”一句作注时说：“表证罢为无阳”。可见“无阳”在此指已无伤寒表实证而言，故不可再用麻黄汤发汗。后世不少注家，把本条作了语句上的调整，改为“太阳病，发热恶寒，热多寒少，宜桂枝二越婢一汤。脉微弱者，此无阳也，不可更汗。”并把脉微弱当做极微的阳衰之脉，把“无阳”解作亡阳。亡阳者，阳气灭也，阳气失也。本条讨论表郁里热证治，与亡阳并无关系，故这种解释与作者原意不符，仍以成注之言为是，断为表郁而生热之轻证，治用桂枝二越婢一汤。

桂枝二越婢一汤，即桂枝汤与越婢汤的合方，也可以说是桂枝汤加麻黄、石膏，并制小其剂而成。用桂枝汤加麻黄解表开郁，用石膏清阳郁之热。因用量较轻，发汗解热之力较弱，故仍属小汗方之范畴。当表寒部分化热，证见热多寒少，麻黄汤、桂枝汤、大青龙汤都不宜用时，只能选此方辛以透表，凉以解热。因此，带有一定的辛凉解表之意。方名“越婢”，有两种解释：一是，“越”有发越之意，“婢”同卑，指地位低下，力量弱小。越婢指发越之力如婢，不如大青龙汤发汗清里作用为大。二是，《外台秘要》把越婢汤称为“起脾汤”，言本方有发越脾气，通行津液的作用。

桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤，都是发小汗的方剂，用于营卫之小邪不解者。营卫小邪不解，都有一点寒热交作如疟的情况，或一日二三度发，或一日再发，或热多寒少，或身必痒，总与一般的太阳表证之发热恶寒不同。临床遇到这些情况，要注意是否是三个小汗方的适应证。此三方既是小汗方，在用量上一定要注意小而轻，不可失张仲景的原意。

服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者，桂枝汤去桂，加茯苓白术汤主之。（29）

桂枝去桂加茯苓白术汤方：

于桂枝汤方内去桂枝，加茯苓、白术各三两，余依前法，煎服。小便利，则愈。

【解析】本条论述汗下后水邪内停的证治。

对本条证治，注家历来争论较多，争论的焦点是有无表证及去桂枝还是去芍药的问题。《医宗金鉴》认为“去桂当是去芍药”。成无己则模棱两可，不言去桂枝还是去芍药，却提出用桂枝汤加茯苓白术为宜。而柯韵伯、陈修园则维持原意，主张去桂枝加茯苓、白术。

本条开首即言“服桂枝汤，或下之”，可知前医认为“头项强痛，翕翕发热”为桂枝汤可汗证，而或以“心下满，微痛”为可下证。然汗下后，前述诸证仍在，并未取效，其故为何？乃因他们不知“小便利”是辨证的关键所在。小便利为气化不利，水邪内停的反映。太阳之气的气化作用与水液代谢的关系很密切，水邪内留，必然影响太阳腑气不利，气化失司，而使小便利。若水邪郁遏太阳经中之阳气，可见经脉不利的头项强痛和翕翕发热之证，似表证而实非表证。若水邪凝结，影响里气不和，可见心下满、微痛之证，似里实而实非里实，故汗下两法均非所宜。用桂枝汤去桂枝加茯苓、白术，健脾利尿以祛水邪，使太阳经腑之气不郁，则本证可愈。

桂枝去桂加茯苓白术汤方后注云：“小便利，则愈”，说明本方作用不是发汗而是通利小便，无需桂枝走表以解肌，故当去之。有人说，既然不发汗而专利小便，何不用五苓散呢？五苓散方后注云：“多饮暖水，汗出愈。”其见小便利，微热消渴，脉浮之证，治取发汗以利水的方法，乃外窍得通，则里窍自利，为表里两解之法。而本方则仅仅利水而已，里窍通，水邪去，则经脉自和，是利水以和外之法。唐容川说：“五苓散是太阳之气不外达，故用桂枝，以宣太阳之气，气外达则水自下行，而小便利矣。此方是太阳之水不下行，故去桂枝，重加苓术，以行太阳之水，水下行，则气自外达，而头痛发热等证，自然解散。无汗者，必微汗而愈矣。然则五苓散重在桂枝以发汗，发汗即所以利水也；此方重在苓术以利水，利水即所以发汗也。实知水能化气，气能行水之故，所以左宜右有。”唐氏的论述可谓是深得此方治疗之旨。

陈慎吾先生曾治一数年低热患者，而有翕翕发热，小便利等证。陈用本方原方，仅两三剂，便热退病愈。足见经方用之得当，其效甚佳。陈修园用本方治吏部谢芝田的验案也很著名，此不赘述。总之，从理论的分析到临床的验证，都以去桂为是。去桂枝后，芍药可助疏泄以治心下满，且配茯苓走里以利尿，苓术相伍健脾利水，姜枣健脾和中调和营卫，共奏健脾气，利水邪之功效。

伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝汤，欲攻其表，此误也。得之便厥，咽中干，烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳。若厥愈、足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸。若胃气不和，**譫**语者，少与调胃承气汤。若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。（30）

甘草干姜汤方：

甘草四两，炙 干姜二两，炮

上**㕮**咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

芍药甘草汤方：

白芍药四两 甘草四两，炙

上二味**㕮**咀，以水三升，煮取一升半，去滓，分温再服之。

调胃承气汤方：

大黄四两，去皮、清酒浸 甘草二两，炙 芒硝半斤

上三味**㕮**咀，以水三升，煮取一升，去滓，内芒硝更上火微煮，令沸，少少温服。

四逆汤方：

甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生用，去皮，破八片

上三味**㕮**咀，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服，强人可大附子一枚，干姜三两。

【解析】本条以举例示范的形式，论述伤寒夹虚误汗的变证及随证

救治的方法。

阴阳气血俱虚之人复感外寒，因其阳不摄阴而证见自汗出，小便数；阴血不足，心神失养而见心烦；表有寒邪而见脉浮，微恶寒；阴血虚少，筋脉失滋而见脚拘挛、抽掣、疼痛即“脚挛急”之证。本证治疗可考虑使用桂枝加附子汤解表兼以固阳摄阴。但医误认为是“卫

强营弱”的太阳中风证，而反投以桂枝汤发汗，从而犯虚虚之戒，导致阴阳更虚，出现了阳虚之手足厥冷；阴伤之咽中干燥；虚阳扰动之烦；阴液亏耗之躁；以及里气不和之吐逆，遂使病情复杂化。此时则应随证施治。在阴阳俱虚，阳不摄阴之时，主要矛盾常在阳虚一面。阳固则阴存，阳生则阴长。何况有形之阴不能速生，而无形之阳则有顷刻而亡的危险，故先以甘草干姜汤以复其阳。待阳回厥愈足温之后，唯脚挛急尚未缓解，再用芍药甘草汤滋阴和血，缓解痉挛，其脚即可伸展。本有阴液不足之证，若用甘草干姜汤扶阳之后，由于阳复太过，使阴液更伤，而胃中燥热，以致胃中不和^证语者，可少少给点调胃承气汤，意在和胃燥而调胃气，并不在于泻下。本以阳气不足，若在治疗中误用了发汗力强的麻黄汤，或者反复多次发过汗，甚至又用烧针劫汗，即“重发汗，复加烧针”的误治，则可导致伤阳的重证而见厥逆吐利等证，救治之法，当急用四逆汤回阳救逆。对这种阳虚重证，甘草干姜汤已不能胜任回阳之重任了。

本条误治后变证多端，虚实寒热互见，阴阳转化无常。其治或扶阳，或滋阴，或和胃，或回阳，治从证变，仲景在此对“观其脉证，知犯何逆，随证治之”的法则作了典型示范，对人启发很大。

甘草干姜汤共两见，一见于《伤寒论》，一见于《金匱要略》，《金匱要略》用此方则治疗虚寒肺痿。本方用量甘草之量要大于干姜，用以扶脾胃之阳，但此证除阳虚外，还有脚挛急、咽中干等阴虚之证，因此在扶阳时要特别注意不可耗伤弱阴，这也就是用干姜而不用附子的原因。由于扶阳之药多刚燥，故不仅要避免用燥烈之附子，而且还要倍用甘草监干姜之峻，以护其阴，且用经过炮炙的干姜，缓其性，亦可防劫阴之弊，可见仲景用药精心之处。《朱氏集验方》用此方治脾胃阳虚，气不摄血的吐血不止、脉迟身凉等证，方名二神汤，足见此方既可扶阳而又能摄阴。

芍药甘草汤所用芍药与甘草剂量相同，均为四两。二药相合，酸甘合化为阴，可以养血、平肝，缓解筋脉拘挛，善治血脉拘急疼痛。对于因血虚而引起的两足痉挛性疼痛或腓肠肌痉挛性疼痛不可伸者，多有良效，故有“去杖汤”之美称。

曾治一曹姓患者，年五十三。腓肠肌痉挛多于夜间发作，脉弦而舌红，用本方四剂而愈。

又治一周姓女孩，年十二。左臀外伤后肿痛，左下肢拘紧不能伸，且有发热。T37.8℃，脉弦细数，西医诊断为化脓性髋关节炎。从脉象分析，弦为肝脉，细为血虚，数为有热，此肝血不足，筋脉不利且有郁热之证。先用芍药甘草汤三剂，其左腿已可伸动。又进两剂，竟可伸直，随之髋部胀痛亦减。因局部仍有红肿及热感，遂换用仙方活命饮连服数剂，而逐渐痊愈。

调胃承气汤由芒硝、大黄、甘草三药组成，它是以咸寒、苦寒，又佐以甘温而成。本方硝黄可泄胃肠之燥热，妙在一味甘草，能缓硝黄之力，使之作用在于胃，有润燥和调胃气的功能，所以它既能调和胃气，又能通肠下便，一方而具两法，陈修园称为“法中之法”。由于本证主要用其调胃，因此在服法上要求“少少温服”，使胃中不燥，胃气调和，则谵语自止。后世使用调胃承气汤清泻胃热、调和胃燥很是多见，如《张氏医通》治心胃火盛，病人常觉面部有如火烤之热的“燎面症”，即用调胃承气汤加黄连、犀角。也有的医家用于治疗过服补药而造成的胃热生斑之证，每获佳效。

四逆汤以附子为主，重在温少阴以回阳救逆。且附子生用又佐以干姜、甘草，是取其效速而力大持久，常用于阳脱、亡阳之急救。其主治及适应证，可与“少阴病篇”合参。

问曰：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸，后如师言。何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮则为风，大则为虚，风则生微热，虚则两胫挛。病证象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也。厥逆咽中干，烦躁，阳明内结，谵语，烦乱，更饮甘草干姜汤。夜半阳气还，两足当热，胫尚微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸，以承气汤微溲，则止其谵语，故知病可愈。（31）

【解析】本条为进一步解释上条而设。解析从略。

【小结】

本篇共31条，从第1条至第12条是全书的纲领，也是太阳病的纲领，它有指导全书与统领辨证的深远意义。这12条的内容，除论述了太阳病的提纲证以外，还有辨病发阴阳，辨真假寒热，辨中风、伤寒，辨传经与否，辨类证的异同，辨欲解的时间，虽有论而无方，但却是辨证的总纲，所以它是太阳病的总论。从第13条起，则有论、有证、有方，

它属于太阳病的各论。而主要论述了太阳病中风证的桂枝汤证，以及桂枝汤的加减证和桂枝汤的禁忌证。最后又为“随证治之”的精神，作了具体的说明。

辨太阳病脉证并治法中

【概说】

本篇继上篇太阳表病的类型之一——太阳中风证治之后，主要论述了太阳表病的另一大类型——太阳伤寒证治及一些有关方证。并进而论述了太阳腑证的两大类型——太阳蓄水与太阳蓄血的证治，从而完善了太阳病辨证论治体系。本篇又列举了许多变证的救治方法，实寓有治疗杂病的意义在内，并通过论述邪传少阳后出现的少阳病证治，以说明太阳之邪入里或传阳明，或传少阳，并无固定规律，关键取决于人体的素体因素。

太阳病，项背强^{几几}，无汗，恶风，葛根汤主之。（32）

葛根汤方：

葛根四两 麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮 芍药二两，切 甘草二两，炙 生姜三两，切 大枣十二枚，擘

上七味^㕮咀，以水一斗，先煮麻黄葛根，减二升，去沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，复取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。

【解析】本条论述太阳伤寒，经输不利的证治。

经脉为气血通路，太阳表邪不解，经脉受邪，气血运行不畅，经输为之不利，因而出现项背强^{几几}的证候。若此筋脉拘急反见汗出恶风等证，则为太阳病中风无疑，用桂枝加葛根汤治疗已如前述。若项背强^{几几}，无汗而恶风寒的，则为伤寒表实证，是寒邪外闭，玄府不通，经脉气血不利所致。“恶风”乃恶寒之互词。治当发汗散寒，疏通经脉，用葛根汤主之。

从用药来看，葛根汤即桂枝汤加麻黄、葛根。其中葛根为主药，既能配麻桂解肌发表，又能升津液、濡筋脉以治项背强^{几几}。表虚之项背强^{几几}，用桂枝加葛根汤，本证属表实经输不利，为何不用麻黄汤

加葛根呢？这是因为，麻黄汤发汗力强，再加入葛根之升阳发表，恐汗出太多。此证为经输不利，应发经输之汗，但也应看到筋脉失滋，拘紧不柔，用麻黄汤加葛根极易造成汗多津伤，而达不到滋润燥，缓和筋脉拘挛的目的。故选用桂枝汤加麻黄、葛根，既可发汗散寒而又不致大汗伤津，且有芍药、甘草、大枣滋阴化阴以缓和筋脉之急，甚合病情。

在临床上，有很多项背疼痛的病人，用葛根汤治疗常可取效。服葛根汤后有的病人项背疼痛处有发热的感觉，这是阳气将要通达的反应，紧接着项背部就会出汗，随之出汗延及全身而病愈。正如曹家达在《经方实验录》中所说：“服后顷刻，觉背内微热，再服，背汗遂出，次及周身……病遂告差。”

本方煎服法，要注意先煎麻黄、葛根，去上沫，然后入诸药。这样做一方面可以缓麻黄、葛根辛散之性，防止发汗力太强而汗出过多；一方面可以减弱麻黄走散之悍，以免药后发生心悸、心烦、头晕等副作用。服药后不必啜粥，温覆即可出汗。

太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。（33）

【解析】本条论述太阳与阳明合病而见下利的证治。

两经或两经以上病证同时发生，无先后次第之分者，谓之合病。合病的发生，多由于邪气过盛，以致同时侵犯数经，其病势也较一经发病为重。“太阳与阳明合病”，在此是指太阳与阳明经表同时受邪，既表现有恶寒发热、头项强痛等太阳经表证，又有缘缘面赤，额头作痛，目痛鼻干，卧寐不宁的阳明经表证。关于阳明经证，《伤寒论》中讲得并不太清楚。原文第49条仅提到“面色缘缘正赤”一证，很不全面。近年来，许多学者把白虎汤证作为阳明经证，混淆了经的概念，也不尽合适。严格地说，白虎汤证作为阳明热证似为贴切。根据庞安时《伤寒总病论》与朱肱《类证活人书》等书的记载，均以阳明经脉为病才叫做经证。而《医宗金鉴》对阳明经证又作了歌诀予以概括：“葛根浮长表阳明，缘缘面赤额头痛，发热恶寒身无汗，目痛鼻干卧不宁。”这里所说的葛根汤证即阳明经证，是阳明经脉受邪，经气被遏所表现的证候，因其经也行于表，故也有发热、恶寒等全身症状。二阳合病，由于太阳、阳明二经受邪多少不同，病变也有所侧重，若太阳病证偏重者，可用麻黄汤，如第37条所述：“太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤”即是其例。本条的二阳合病，其中以阳明经邪为重，这可从“必自下利”一证而知。太阳与阳明经表受邪，尤以阳明经邪为重，由于阳明之气抗邪于表，不能顾护于胃肠之里，里气不和，升降失常，所以出现自发的下利或呕吐等证。以下利为主者，治用葛根汤以解经表之邪，升阳明之

气。表解则里和，下利必自止。

葛根汤为阳明经证正治之方，又可兼解太阳表邪，方中主药葛根，不仅能解肌发表，且能入脾胃，升发清阳，鼓舞胃气，善治泄利，故本方治二阳合病，自下利者，最为合适。

太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。（34）

葛根加半夏汤方：

葛根四两 麻黄三两，去节，汤泡去黄汁，焙干称 生姜三两，切 甘草二两，炙 芍药二两 桂枝二两，去皮 大枣十二枚，擘 半夏半斤，洗

上八味，以水一斗，先煮葛根、麻黄，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，复取微似汗。

【解析】本条承上条论述二阳合病，表邪不解，影响里气不和，不下利但呕的证治。

太阳与阳明合病，表邪不解，两经的阳气抗邪于表，不能内顾于里，造成里气不和，升降失常。有时可见下利，有时可见呕吐，有时则吐利并见。呕吐是胃气不降之证，由于发生于太阳、阳明表邪不解以致里气不和、升降失常，故其治疗仍当解两经之表，故用葛根汤加半夏和胃降逆以止呕吐。

在临床上，表气不和影响里气不和的情况很多见，如桂枝汤证中有干呕，麻黄汤证中有呕逆等皆是。有的人，一感外邪则见吐利不止，现称之为“胃肠型感冒”。此类病在治疗上应以解外为首要。外邪得解，里气自和，升降复常，吐利亦当自止。

葛根加半夏汤即葛根汤原方原量加半夏半斤（赵本为半升）。煎服法与葛根汤同。

太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄连黄芩汤主之。（35）

葛根黄芩黄连汤方：

葛根半斤 甘草二两，炙 黄芩二两 黄连三两

上四味，以水八升，先煮葛根，减二升，内诸药，煮取二升，去滓，分温再服。

【解析】本条论述里热夹表邪下利的证治。

病为太阳中风桂枝汤证，医误用下法，而使表邪内陷入里，出现腹泻不止的症状。“医反下之”，是病在表不当下而下，故加一“反”字，此应看做是病机转折的一个条件，临证切不可拘泥。表邪入里以致“利遂不止”，究属虚属实属寒属热，应凭脉辨证以作出诊断。“脉促者”，即脉数而促迫，非为数而中止之促脉。脉数为里有热，且反映人体阳气为盛。阳气盛，有抗邪外达之势，则表邪未能全部内陷，故曰“表未解也”。既有表邪未解，又有里热下利，故可称之为里热夹表邪而下利，或称“协热利”。表邪束肺，里热迫肺，肺气不利故喘。里热逼迫津液外越故汗出。表里皆热，而发热一证也自在言外。既为热利，其大便黏秽，暴注下迫，下利肛热等证则在所不免。治疗采取解表清里，表里两解的方法，用葛根黄芩黄连汤。

葛根黄芩黄连汤是《伤寒论》中以葛根为主药的方剂之一，然葛根用至半斤，则是罕见的。葛根味辛性凉，既可解肌热，又可清肠热，还可升胃肠津气。先煎是取其解肌清肠为主。黄芩、黄连苦寒专清里热，坚阴以止利，加甘草扶中护正，调补下利之虚，助正以祛邪，如此表解里清则利止喘平。从本方用药来看，知此证中表邪少而里热多，可以说仅有三分表证，而七分则是里证。

综上所述，葛根汤既可用于风寒在表，太阳经输不利，项背强几之证，也可用于太阳、阳明合病，正气抗邪于表而不能顾护于里，里气不和，升降失常，下利呕吐等证。而葛根芩连汤则用于表里皆热、协热下利之证。以葛根为主药的这两个方子，为临床所常用，且疗效也好，应掌握其脉证。

太阳病，头痛发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。（36）

麻黄汤方：

麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮 甘草一两，炙 杏仁七十个，汤去皮尖

上四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，复取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

【解析】本条论述太阳伤寒表实证的证治。应与第3条的“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒”互参。

本条提出有头痛、发热、身疼、腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗、气喘等八个证候，因是伤寒的病变反映，治以麻黄汤，故称之“伤寒八证”或“麻黄八证”。这八证中，概括起来可分为疼痛、寒热与无汗而喘三组。中风为风邪伤卫，伤人较浅。伤寒则为感受寒邪，因寒性凛冽，故伤人较深，可由卫透营，足以外闭卫阳，内伤营血。寒性凝滞收引、主痛。寒邪袭表，使营血运行涩滞不畅，经脉筋肉拘紧，故见诸痛。头痛为“头项强痛”的省文，身疼与骨节疼痛并不相同，故当分别辨析。头项、腰脊是太阳经脉循行之处，寒伤太阳，经输不利，所以头项作痛，腰脊疼痛。正如《灵枢·经脉》所云：“膀胱足太阳之脉……是动则病冲头痛，目似脱，项如拔，脊痛腰似折。”筋主束骨而利机关，太阳“主筋所生病”，故太阳感寒则骨节疼痛。“恶风”是恶寒的互词，和前第3条合参，知为伤寒必见证。因寒为阴邪，最易伤人阳气，卫阳被伤，因此必恶寒。寒主收引闭敛，全身毛窍腠理为寒邪所闭塞，所以无汗。卫阳之气被闭郁而不得宣泄，所以发热。肺合皮毛而主表，表闭无汗，影响肺气的宣发，故作喘。“无汗而喘”既提出了两个单独的证候，也揭示了无汗与喘的因果关系，即无汗是造成喘的原因。而一旦汗出表解，则肺气自可宣降，而喘也自平。同时“无汗而喘”也便于和肺热的“汗出而喘”相鉴别。本条详于证而略于脉，从第3条可知，太阳伤寒应见浮紧之脉，且寸关尺三部均应浮紧，方属太阳伤寒正证。治当发汗散寒，唯麻黄汤可胜此任。

麻黄汤为发汗散寒，解表逐邪之峻剂，是治疗太阳伤寒的主方。麻黄发汗散寒，开毛窍，启闭平喘。桂枝通阳，助麻黄以发散风寒。杏仁利肺平喘，并助麻桂解表发汗。甘草和中护正。用此方，应恰当掌握药量的比例，一般情况以麻黄：桂枝：甘草=3:2:1为宜，若比例不当，则可能影响发汗解表的治疗效果。本方发汗力强，药后只需温覆即可发汗，不必啜粥。其他注意事项、发汗要求与禁忌，与桂枝汤同。煎药时要注意先煎麻黄去上沫，以免令人心烦。

典型的麻黄汤证在北京地区并不多见，此方在临床上用之较少，这也是事实。但我国幅员辽阔，气候各异，特别是在高寒地区，正伤寒证却并不少见，故不可轻易废弃此方。此外，从本条可以看出，麻黄剂治疗诸痛是有效的，特别适用于治疗寒性的疼痛。如用于治疗痹证疼痛的小续命汤、桂枝芍药知母汤等，都有麻黄。还可看出，麻黄剂治喘也有卓效，除麻黄汤以外，小青龙汤、麻杏甘石汤以及后世的定喘汤等治喘

效方，都以麻黄为主。现代医学用麻黄素治喘，而早在1700百年前的《伤寒论》中就已经广泛地使用麻黄来治喘了，这是了不起的贡献。另外，麻黄剂还能治疗一些由于寒邪闭塞而引起的病证。如曾有医案记载某医治一患太阳伤寒证的难产妇人，投麻黄汤一剂，随之汗出而婴儿落生。说明此难产可能与寒邪闭塞，营卫气血不畅有关，发汗使寒邪去，闭塞开而胎儿自娩。由此可见，即使在伤寒很少见到的北京地区，用麻黄剂治疗感寒所致的疼痛、多种喘证以及因于寒邪闭塞所引起的其他病证，还是大有用武之地的。

太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤主之。（37）

【解析】本条论述二阳合病，重在太阳的证治。

太阳与阳明经表之证同时存在，当邪气重在阳明时，则见自下利或不下利但呕之证，治疗用葛根汤或葛根加半夏汤，已如前述。本条讲的是病变重点在于太阳。太阳邪盛，表气闭郁使肺失宣降故见喘。肺气不利，因而胸满。本证矛盾的主要方面是太阳之气被郁，故用麻黄汤发汗散寒启闭则可取效。由于肺与大肠相表里，肺失宣降，亦可影响大肠腑气不利而见大便不下。但并不能因此而用下法，因证见胸满而非腹满，故非里实，如误下，则往往导致表邪内陷而生变证。

同是太阳与阳明合病，由于病变重心不同，则遣方用药亦不同。重在太阳以喘为主者，用麻黄汤；重在阳明经表，以下利为主者，用葛根汤。界限分明，不可混淆。

太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤。脉但浮者，与麻黄汤。（38）

（小柴胡汤方：详见后文第100条）

【解析】本条论述太阳伤寒日久的几种转归。

这里的“太阳病”，从后文“脉但浮者，与麻黄汤”，可知指的是太阳伤寒而言。太阳伤寒已过十日，脉由浮紧变为“浮细”，即脉虽浮，但不那么紧急有力。其证仅见乏力“嗜卧”，而寒热头项强痛之证已除。以上脉证说明，表邪已去，正气渐复，已无所苦，故谓“外已解也”。既然外邪已解，虽病体略有不适，也无需服药，只要安心静养即可，这是一种转归。“脉但浮者，与麻黄汤”，是说太阳伤寒虽已过十日，但还见伤寒的浮紧之脉，并以此暗示太阳伤寒的发热恶寒、头身疼痛诸证仍在。既然脉证不休，病仍在太阳，属伤寒表未解，故治法与方药亦应不变，仍应考虑使用麻黄汤。但由于“十日以去”，病程日久，即使伤寒诸证仍在，可以再用麻黄汤发汗，亦应斟酌、考虑，谨慎使用，故不言“主

之”，而言“与”，以示区分。以上属于表邪留连未解，是第二种转归。第三种转归，证见“胸满胁痛”，反映少阳枢机不利，说明邪气已由表传入少阳之经。治用小柴胡汤和解少阳，以利枢机。

从本条所举太阳伤寒日久的几种转归可以看出，虽“太阳病，十日以去”，但病邪却不一定会发生传变。其中有向愈者，亦有表邪仍不解者，而只要表证不解，就应再用解表的方法治疗。凭脉辨证是推断病情发展变化的主要依据，不可拘泥于病程长短，这个精神，在本条又得到了很好的体现。

太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服。服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也。（39）

大青龙汤方：

麻黄六两，去节 桂枝二两，去皮 甘草二两，炙 杏仁四十个，去皮尖
生姜三两，切 大枣十二枚，擘 石膏如鸡子大，碎

上七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，取微似汗，汗出多者，温粉扑之。一服汗者，停后服。汗多亡阳，遂虚，恶风烦躁，不得眠也。

【解析】本条论述了伤寒表实兼内热烦躁的证治，及大青龙汤的禁忌证与误服后的变逆。

“中风”是伤寒的互词，“太阳中风”实指太阳伤寒而言。从其所见脉浮紧，发热恶寒，身疼痛等证候看，也可确定属伤寒表实无疑，当用麻黄汤治疗。“不汗出”既是一个证候，也可以看做是治疗不当，或因循失汗（如未就诊，或虽就诊而医者未用汗法），或虽用汗法，但病重而药轻，没有达到发汗的目的。汗不得出，寒邪在表不解，阳气闭郁不伸，进而化热，内热扰心故生烦躁。不汗出是造成烦躁的原因，烦躁是不汗出的结果，故云“不汗出而烦躁”。这种情况在临床上多见于体质强壮，正气抗邪有力而邪气又盛的患者。寒邪闭于表而不能入里，阳气郁于内而不能外泄，俗语所说让汗憋得烦躁不宁，即是这种情况。但由于本证仅是不汗出而致烦躁，并不见口渴、引饮等阳明里证，故属邪在于表而兼有阳郁化热的病证，此时用麻黄汤，虽有散寒开闭之力，但无清里解热之能，则已非所宜。故用大青龙汤峻发在表之邪以宣泄阳郁之热，则

表可解而烦躁得去。若其人脉不浮紧而见微弱之象，又见汗出恶风等证，说明证属荣卫俱虚或卫强荣弱，而非荣卫皆实。如果误投峻汗之大青龙汤，则可因过汗亡阳，阳气不能充达四肢，而致四肢厥逆；过汗亡阳脱液，筋肉失养，则见筋惕肉瞤。因治疗错误而导致病情变坏，故云“此为逆也”。

大青龙汤是麻黄汤重用麻黄再加石膏、生姜、大枣而成，为发汗之峻剂。倍用麻黄，佐桂枝、生姜辛温发汗散寒以启表闭，加石膏辛寒，一可配麻黄解肌以开阳郁，又可清热以除烦躁。甘草、大枣和中以滋汗源。方后注有“汗出多者，温粉扑之”一句，知此方发汗力甚强，不易控制。因此，当汗出太多时，防治之法是以温粉扑于身上。温粉即炒米粉。用炒米粉扑身是汉时流行的一种止汗方法。尽管如此，仍有汗出多而伤阳气，以致造成阳虚恶风或阳虚阴盛，烦躁不得眠等诸种变逆的发生。故对于使用大青龙汤的病证，服药后在控制发汗的大小多少上，还应特别注意。

我院某进修生曾治一壮年社员。该社员于夏季大汗如洗之时入井工作，井下阴寒如冰，下井后，全身大汗顿消。随之患全身疼痛、恶寒、发热、无汗、烦躁之证，服他药无效。该医生望其人面赤气粗，切其脉浮紧而数，此大青龙汤证已无疑。然时值盛夏，不敢贸然进药，乃与他医研究。他医说可用药，如汗出虚脱可用西药急救。遂与大青龙汤原方，仅服一煎则汗出热退，诸证霍然而愈。

《金匮要略》用大青龙汤治疗“饮水流行，归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重”之“溢饮”证，用其发汗以解水毒，主要治水邪在末梢、皮下。曾治一患者，两手酸沉肿胀，身体肥胖，服黄芪、防己等益气利水药和注射维生素B₁、维生素B₁₂等药未取效。用大青龙、越婢汤之意，药后汗出而病愈。

伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。（40）

【解析】本条承上条再论大青龙汤的证治及其与少阴证的鉴别。

太阳伤寒，脉由浮紧变为浮缓，证由身痛变为身重且偶有减轻之时，这反映了在表的寒邪有随闭郁不伸的阳气化热的趋势。寒邪渐趋化热，脉则自然由紧变为不紧，证则亦随之由身疼痛变为不疼。但虽渐化热，却尚未入里，仍在于表。表闭未开，阳气仍然闭塞，全身气机不利，故见身重。邪气又有入里之势，进退于表里之间，故身重一证又乍有轻时。表气闭郁，里有郁热，则烦躁与发热之证也自在言外。上条述表寒闭郁，偏于外；本条论表寒部分化热，趋于里，但并未见烦渴欲饮

之白虎汤证，故仍用大青龙汤发之。因少阴阳衰也会出现身重烦躁等证，所以要注意和本条所述大青龙汤证的身重相鉴别，勿犯虚虚之戒。少阴阳衰应有脉微细、四肢厥逆、精神不振等真阳衰微之证可见，远非大青龙汤之阳热证可比。

对上两条所提到的“太阳中风，脉浮紧”，“伤寒，脉浮缓”，和大青龙汤的应用，历代注家意见很不一致。除一部分注家认为文字可能有错简外，其他观点基本可分两派：以成无己、许叔微、方有执等为代表者认为：桂枝汤证是风伤卫，麻黄汤证是寒伤营，大青龙汤证是风寒两伤，营卫俱病。这就是著名的“三纲鼎立”之说。另一派则不同意这种观点，如尤在泾认为：“桂枝主风伤卫则是，麻黄主寒伤营则非。盖有卫病而营不病者矣，未有营病而卫不病也。至于大青龙汤证，其辨不在营卫两病，而在烦躁一证。其立方之旨，也不在并用麻桂，而在独加石膏。”尤氏的观点与临床实际较为贴切，实有可取之处。

伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。（41）

小青龙汤方：

麻黄三两，去节 芍药三两 五味子半升 干姜三两 甘草三两，炙 桂枝三两，去皮 半夏半升，汤洗 细辛三两

上八味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

加减法：

若微利者，去麻黄加芫花，如鸡子大，熬令赤色。若渴者，去半夏，加栝蒌根三两；若噎者，去麻黄，加附子一枚，炮；若小便不利，少腹满，去麻黄加茯苓四两；若喘者，去麻黄，加杏仁半升，去皮尖。

【解析】本条论述外寒兼内饮的证治。

“伤寒表不解，心下有水气”，是对本条外寒内饮小青龙汤证病机的概括。“发热”一证代表了“表不解”，而恶寒、无汗、身疼痛等伤寒表实见证自在言外。心下胃脘部原有寒饮之邪内停，即所谓“心下有水气”。寒饮扰胃，胃气上逆则干呕；水寒射肺，肺失宣降则咳嗽；水饮之邪变动不居，可随三焦气机升降出入，故有众多或见之证：水饮不化，津液不滋，则可见渴，但不欲饮水；水走大肠，清浊不分，则可见下利；水寒滞气，气机失畅，则可见噎；水饮内停，气化不利，则可见小便不利，甚或少腹胀满；寒饮迫肺，肺气上逆，则可见喘。综上诸证，咳、喘、渴、噎为上焦证候；干呕为中焦证候；小便不利、少腹满、下利为下焦证候，证候虽多，关键为“水气”所致。心下有水饮，外有表寒，治以小青龙汤外散在表之寒邪，内消心下之水饮，此乃发汗消饮，表里两治之法。

小青龙汤由麻黄汤去杏仁加干姜、细辛、五味子、芍药、半夏所组成。麻黄发汗解表，宣肺平喘，兼以利水；配桂枝可增强宣散寒邪，通畅阳气的作用；干姜配半夏，温化中焦的水寒之邪，治心下水气；细辛辛辣而散，温散上中下三焦水寒之邪。原方虽为外解表寒，内散水饮而设，但从药物分析，它在内又有温通三焦，统治上、中、下三焦寒饮之功效。但诸药辛散太过，犹恐耗阴动阳，损伤正气，故用炙甘草甘温以守中扶正，芍药酸敛以护肝阴，五味子酸敛以护肾阴，使本方成为温散寒饮而不伤正气的有制之师。从仲景治疗寒饮的规律来看，尤其是治疗

肺、胃的寒饮，常把干姜、细辛、五味子三药合而用之，对于寒饮之咳喘确有良效。因干姜、细辛可直接入肺，散水寒之邪，五味子入肺可收敛肺气之逆，一收一散，散中有收，正邪兼顾，对消散寒饮而止咳定喘则十分得力。因此在使用本方时，要特别注意这一配合方法。《金匱要略·痰饮咳嗽病脉证并治》中，载有苓甘五味姜辛汤，桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤，苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤，苓甘五味加姜辛半夏大黄汤等几个治痰饮咳嗽的方子，都恰到好处地使用了干姜、细辛、五味子的配合方法。

本方外散表寒、内消寒饮，为表里两治之方，但若无伤寒表证，仅是寒饮内停，证见咳喘者，也可使用。如《金匱要略》用之治疗“溢饮”及“支饮”咳逆倚息不得卧等证，根据临床经验，凡内有寒饮而造成喘咳的病人，常有下列临床表现：患者面色多见青色或黧黑之色，或下眼睑处呈青暗之色，因属水寒郁遏阳气之象，故称之为“水色”；若寒饮阻滞，营卫气血运行不利，则面部可出现对称性的色素沉着，谓之“水斑”；还有的病人，由于水气内留而见面部虚浮，眼睑轻肿，谓之“水气”。水色、水斑、水气的出现，是使用小青龙汤时在望诊上的辨证依据。这类病人大多见弦脉与水滑舌苔。咳喘是本方证的主要见证。寒饮射肺的咳喘，往往是咳而多痰的，且这种寒饮之痰多具有以下特点：一是咳吐大量白色泡沫样痰，落地成水；或是咳吐冷痰，自觉痰凉如粉，痰色似蛋清样半透明，而连续不断。这种寒饮之痰一定要注意与燥痰或热痰胶黏难吐相鉴别。此外，病人还常有短气、憋闷、窒息之感，重者则咳逆倚息不得平卧，甚则咳喘时涕泪俱出，更甚者，可因水气上冲而突然昏厥。因属寒饮为病，故天气暖和时则病情缓解，冬季寒冷时则发作加重。由于水寒之邪为患，多变动不居，故常在主证的基础上出现各种不同的兼证。治疗兼证要随证加减药味，灵活变通，同样能取得良好的治疗效果。本方后所附的加减法，就是张仲景为后世人所作的随证化裁的示范。

本方麻桂并用，又配细辛，虽有芍药、甘草、五味子相佐，毕竟还是辛散峻烈之剂，因此，在服法上要求水煎分三次服，以便使药力不致太猛。尽管如此，在临证时对年高体弱、婴幼儿童，特别是心肾机能虚衰的患者，仍要慎用，恐有拔肾气，动冲气，耗阴动阳之弊。对于一般的病人，使用本方也只是在喘咳急性发作时的救急之法，不可久服多用。且一旦疾病缓解，即应改用苓桂剂（如苓桂术甘、苓桂杏甘、苓桂味甘、苓桂薏甘、苓桂枣甘汤等）温化寒饮，以善其后。曾治一咳喘病人，与小青龙汤三剂，药后诸证已减，本应更方，但患者见服本方有效，未经复诊，自作主张，竟连服小青龙汤十二剂，以致鼻衄不止。后

虽经某医院急救血止，但遗有倦怠、乏力诸证，此即过服辛散，伤阴动血之例。《临证指南医案》喘门中，叶天士有两张治喘的方子，其一用麻黄而不用细辛；其二用细辛、干姜、五味子而不用麻黄，反加茯苓、人参等药。为什么叶氏把麻黄、细辛二药分用而不合用，可能是因为他行医于我国南方，该地气候温暖潮润，人体腠理疏松，因而不敢过用辛温发散之故。这足见后世名家对麻黄、细辛同用，发散力太强，易伤阴动阳的弊病已有深刻的认识。

大、小青龙汤都可以看做是由麻黄汤加减衍化而来，也均属表里两解之方。但大青龙汤发汗散寒兼清阳郁之热而除烦躁，以发汗为主。而小青龙汤发汗，蠲除心下寒饮治咳喘，以蠲饮为主。无论在《伤寒论》或《金匱要略》中，使用大青龙汤都要发汗。而小青龙汤在《伤寒论》中用于表里两解，在《金匱要略》中则仅为温散心下水饮而设。大青龙汤的使用禁忌在《伤寒论》中已述，故在《金匱要略》中不再重复，此详于前而略于后。小青龙汤的使用禁忌在《伤寒论》中无载，而在《金匱要略》中却有明文，此详于后而略于前。《金匱要略·痰饮咳嗽病脉证并治》所云：“咳逆倚息，不得卧，小青龙汤主之。青龙汤下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难，时复冒者，与茯苓桂枝五味甘草汤，治其气冲。”正是对小青龙汤的使用禁忌和误服本方后的变证以及救治方法的详细记述。尤在泾对这一条作了很好地解释说明：“服青龙汤已，设其人下实不虚，则邪解而病除。若虚则麻黄、细辛辛甘温散之品虽能发越外邪，亦易动人冲气。冲气，冲脉之气也。冲脉起于下焦，挟肾脉上行至喉咙。多唾口燥，气冲胸咽，面热如醉，皆冲气上入之候也。寸沉尺微，手足厥而痹者，厥气上行而阳气不治也。下流阴股，小便难，时复冒者，冲气不归，而仍上逆也。茯苓桂枝能抑冲气使之下行，然逆气非敛不降，故以五味之酸敛其气，土厚则阴火自伏，故以甘草之甘补其中也。”从下虚之人误用小青龙汤后造成动冲气、拔肾气的后果，提示人们对小青龙汤的使用，应严格掌握其禁忌证。尽管在《金匱要略》中，除本条的苓桂味甘汤外，还设有误用小青龙汤后的多种救治之方，但仍以慎用为妥。不过还需指出，治疗总以辨证作为依据，只要辨证准确，则治无禁忌，用此方又每获良效，故亦不可当用不用。

本方以寒饮咳喘为适应证，若属太阴温病，风热犯肺的咳喘，与此则寒热殊异，绝不可错用。

大青龙汤中有石膏，以清阳郁之热而除烦躁。在《金匱要略》中，也有小青龙汤加石膏之方，治“肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，

心下有水”之证，即是用于水饮之邪在内，阻遏阳气而有烦躁证者。

伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴。服汤已渴者，此寒去欲解也。小青龙汤主之。（42）

【解析】本条承上条，补充小青龙汤证的主证及药后寒去欲解的机转。

“小青龙汤主之”应接于“发热不渴”之后，此属倒装句法。“伤寒，心下有水气”与上条“伤寒表不解，心下有水气”之意同，同时也讲了本证的病机。上条所述主证为干呕，发热而咳，本条补述咳而微喘，这正是外寒内饮小青龙汤的适应证。上条或见证中有口渴一证，是因水气不化，津液不滋所致，可在原方中去半夏加花粉治之。本条服用小青龙汤后而见渴者，乃是药后寒饮之邪已去，胃阳之气渐复，里气温，水气散的征象，故此仲景说：“此寒去欲解也。”此之虽渴，但不甚，可不治自愈，少少与饮水即可。若饮水太多，则有郁遏胃阳，导致水饮复聚之患。

太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。（43）

【解析】本条论述太阳病脉见浮弱者，治宜桂枝汤。

本条应与第38条所云：“脉但浮者，与麻黄汤”合看。38条之太阳病，脉但浮，实指见浮紧之脉，其证应属伤寒表实，治宜麻黄汤。本条之太阳病，脉非浮紧而见浮弱。弱者，缓弱之象，凭脉辨证应考虑是中风表虚证，治宜桂枝汤。

在连续七条论述麻黄汤以及大、小青龙汤等伤寒表实诸证治之后，从本条开始又再次论述桂枝汤证治，实有虚实对比，以深化辨证论治的意义。

太阳病，下之微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏人汤主之。（44）

【解析】本条论述太阳表证不解，兼有邪陷致喘的证治。

太阳病，只要外证尚在，虽有大便不利之证，也不可先下，而应先解表，表解才可泻下攻里。此即所谓“汗宜早，下宜迟”。若表证犹在而误下，则易伤里气，使表邪乘虚内陷。本条误下之后，只见微喘，说明在表之邪稍稍入里，影响肺气不利而逆于上。但由于矛盾的主要方面还在于表，即所谓“表未解”，故其治仍以解肌发表为主，用桂枝汤，加厚朴、杏仁降气平喘。因下后正气受伤，故不可用麻黄汤峻汗。在临床上，风寒外感兼以轻喘，脉浮有汗者，用桂枝加厚朴杏仁汤亦每获良效。前述“喘家，作桂枝汤，加厚朴杏子佳”一条，讲的是新感诱发宿

喘，用本方主要不在于治喘而是治中风兼以照顾宿疾，为急则治标之法，故曰“佳”。本条为新感表不解，邪陷致喘，是桂枝汤证的兼证，用本方意在发散表邪，宣降肺气，表里兼顾则诸证尽愈，故不曰“佳”，而曰“主之”。

临床治喘，寒饮射肺者用小青龙汤，肺热作喘者用麻杏石甘汤，均大有人在。唯使用桂枝加厚朴杏子汤治喘者却比较少见，而且本方也很少被人重视。其实对风寒外感，汗出而喘者，麻杏石甘汤、小青龙汤均非所宜，只有本方较为好用。蒲辅周先生医案中用本方治喘的记载，是深得此方要领的。本方治喘，以证见脉浮缓、有汗者为准，故在桂枝汤中加厚朴、杏子。叶天士只加杏子而不加厚朴，然其效亦佳。

太阳病，外证未解者，不可下也，下之为逆。欲解外者，宜桂枝汤主之。（45）

【解析】本条论述表里同病，应先解外，治宜桂枝汤。

凡表证未解，又见大便不利之里证时，不可先攻下。如果先行攻下，则属治疗上的错误。这是因为，在一般情况下，邪客于表，当汗之而解；邪结于里，可下之而愈；表里同病，亦应先解表后攻里。若先攻下，总要伤里气，里气受伤，在表之邪则很容易乘虚内传，使病情复杂化。因此，表里同病时，一定要先解外，待表解后，如果里气仍实，方可攻下，这是伤寒六经证治的一条很重要的治疗原则。至于解表，应考虑使用桂枝汤。因此处所言里证乃是不大便，故不宜用麻黄汤峻汗而伤津劫液，只能用桂枝汤滋阴以和阳，调荣而和卫方为得体。

太阳病，先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈。浮为在外，而反下之，故令不愈。今脉浮，故知在外，当须解外则愈，宜桂枝汤主之。（46）

【解析】本条论述太阳病汗、下后不解仍可再汗。

太阳病，本应发汗而解。今“先发汗不解”，说明可能为表里同病，或汗不得法，或病重药轻，以致一汗不解。既然表不解，就应再以汗解，虽有里证亦不应攻下。否则误下必伤正气，可引起表邪内陷，变生他病，今表不解而复下之，察其脉仍见浮，说明病邪仍在太阳之表，没有内传。“浮为在外，而反下之，故令不愈”，是自注句，指出病不解的原因是当汗未汗，而反用下法则误。由于病为汗下之后，故虽应再汗，亦不可用麻黄汤峻汗，当选用桂枝汤为宜。

太阳病，有一汗不解可以再汗之法；阳明病，有下后余热复聚，可以再下之法。临证以辨证为准，有是证则用是法，切不可动摇不前。

太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。服药已，微除，其人发烦目瞑。剧者必衄，衄乃解，所以然者，阳气重故也。麻黄汤主之。（47）

【解析】本条论述太阳伤寒，迁延日久，服麻黄汤后可能发生鼻衄而解的情况，并指出欲衄的先兆及衄解的原因。“麻黄汤主之”应接于“此当发其汗”之后。

太阳病，见脉浮紧、无汗、发热、身疼痛，为典型的太阳伤寒表实证。若其证迁延八九日不解，仍应再用麻黄汤发汗。若药后见不汗出而烦躁，则属表闭太甚，阳热内郁之大青龙汤证。今“服药已，微除”，即言略发一点汗，证候稍减，但不彻底。然为何不能汗出而病愈呢？这是因为卫闭营实，没有得到及时的治疗，迁延至八九日，以致阳气受寒邪的郁遏太甚，即所谓“阳气重故也”。此时即使用了麻黄汤，也仅仅能稍稍出点汗，使卫分之邪稍减而营中之邪却不能尽去。尽管如此，但药后正气得药力之助，使阳气振奋，则可能出现“战汗”作解或鼻衄作解的两种情况。这两种自解的情况，多见于邪气壅实而体质壮盛之人。本条论述的是鼻衄作解的情况：鼻衄作解，又称“红汗”，是邪气不能外解，阳郁太甚，以致内逼营分，迫血妄行，从清道鼻窍而出。汗血同源，邪不从汗解，即可从衄而解。在衄解之前，因阳气发动，欲驱邪外出，正邪相争，患者常可出现烦热、两目畏光而欲闭目，或头晕等先兆证候。而一经衄血，如出血痛快，则使营分之寒邪可随之而去，诸证随之而愈。这个过程或称“衄以代汗”，或谓“出红汗”、“出大寒”等证名。

太阳病，脉浮紧，发热身无汗，自衄者愈。（48）

【解析】本条承上条再论太阳伤寒表实可自衄而解。

“脉浮紧，发热身无汗”，属太阳伤寒表实证无疑。太阳伤寒表实，若未经发汗，则必使阳郁甚，邪内迫于营分。对于身体壮实的患者来说，常因机体自然抗病能力的发挥而有驱邪外出的转机，此时邪气外出的途径常常是鼻衄，通过衄血将营分的寒邪祛除。若病人不能衄血以自愈的，亦可考虑施以针刺放血的办法。此法现仍流传于民间，用于治疗各种热病，就是这个道理。如对因于外感所致的高热患者，用三棱针在曲池、少商、太阳穴等处放血，多能取效。基于上述原因，在临床上对外感高热的病人发生鼻衄时，亦要想到可能是自解的机转，不要轻用犀角地黄汤等凉血之剂，以免冰伏邪气。

二阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗。设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之、熏之；若发

汗不彻，不足言，阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气，但坐，以汗出不彻故也，更发汗则愈。何以知汗出不彻，以脉涩故知也。（49）

【解析】本条论述太阳、阳明并病的成因和证治。可分三段进行分析：

第一段，从“二阳并病”到“续自微汗出，不恶寒。”指出太阳病，汗出不彻可以转属阳明。太阳初得病时治用汗法，是正确的。但若发汗不够彻底，则也达不到驱邪外出的目的。表邪不解，就有可能转属阳明。阳明为多气多血、阳气昌隆之经。里热盛，则逼迫津液外越而见汗出，表邪已净，则不恶寒。故汗出、不恶寒，是表邪全部入里，阳明燥热已成的表现，治疗应用下法。

第二段，从“若太阳病证不罢者”起，至“当解之熏之”止。主要论述太阳、阳明并病的证治。若太阳之邪仅部分入里而太阳病证不罢者，则称“二阳并病”。二阳并病，邪气入里并于阳明，又有入腑与入经的不同。若太阳表证不罢，虽阳明燥热已成，亦不可先用下法，因为先攻下，易使表邪内陷发生他变，此时应先解表后攻里。但因部分邪气已经入里，在表之邪已减，故亦不可用大汗之法，因大汗使津液越出反有助阳明燥热之弊，故以小汗为宜。若太阳表邪不罢，部分邪气内传阳明之经，则证见“面色缘缘正赤”，赤为红之甚，正赤乃深红之色。“缘缘正赤”指满面通红，且从表皮到深层都很红。既非局部带红，也非浮红、泛红、嫩红，和虚阳上浮之面赤截然不同。它较“以不得小汗出”而有小邪不解的“面有热色”之红为更深。这是阳明经中之邪怫郁不散，使阳气不得发越之故，还应伴有恶寒、发热等证。“解之熏之”，均指汗法而言，可用葛根汤清解阳明经热，兼解太阳表邪。

第三段，从“若发汗不彻”起，至全条结束。进一步论述了二阳并病的成因和主证。造成二阳并病的原因，是太阳病发汗不彻所致。由于当汗不汗，不仅使表邪不能发散，而且使阳气怫郁不得发越。阳郁进而化热，则生烦躁。邪气外闭，肺气不利，则“短气，但坐”而不能平卧。太阳主皮毛，阳明主肌肉，二经邪气不解，营卫之气滞涩不利，则痛无定处，忽而腹中，忽而四肢，按之又找不到明确的痛处。以上诸证，究其原因，皆因汗出不彻，使二阳经气闭郁所致。何以知是汗出不彻呢？除上述证候外，还可见到涩滞的脉象。脉涩反映了邪气凝滞未散，营卫郁遏不畅。其治应再发汗，以疏解二阳经表之邪，其病可愈。

脉浮数者，法当汗出而愈。若下之，身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，

便自汗出愈。（50）

【解析】本条论述伤寒夹虚的证治。

“脉浮数”，含有脉浮紧之意。一般说来浮紧之脉略带数象，浮缓之脉略有迟意。今脉浮紧，知为太阳伤寒证，应以麻黄汤发汗为宜。若误用下法，必伤害里气。正气受伤，气虚乏力，故见身重。气虚心无所主，因而心慌心悸。此时如表邪仍在，则亦属伤寒夹虚之证，不能再发汗的治法。误下后正气亏虚，不仅见有身重、心悸等证，而且从“尺中脉微”更可以得到证实。“尺中脉微”，即指尺脉微。尺以候里、候肾，微为虚脉，尺脉微反映里气已虚。此时如误发虚人之汗，常会导致邪气未去，而正气被伤，使病情恶化。怎样处理才好呢？一方面可借助于饮食、调养，待正气恢复，阴阳自和，表里正气充实，正气能以驱邪外出，则自汗出而愈。另一方面，若不能自愈，即虽等待日久，正气仍不能恢复，则表邪亦不能自解者，根据后世医家主张，可用小建中汤扶中补虚，外调荣卫，此即所谓“实人伤寒发其汗，虚人伤寒建其中”的理论。

在《伤寒论》中，有冲锋陷阵之方，峻烈凶猛之药，大刀阔斧地去攻病逐邪；但也有周全细腻谨慎之至的遣方用药；或立足于调养，寄希望于正复。可谓是因病、因人制宜，量虚、量实用方，这些事例，称得起辨证论治的典范。

脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者，不可发汗。何以知之然？以荣气不足，血少故也。（51）

【解析】本条进一步论述伤寒夹虚不可发汗的原则。

浮紧之脉，若是阴阳俱紧者，则为太阳伤寒表实证的脉象。伤寒表实，寒邪凝滞，营卫不利，必见身疼痛之证，治疗则应以麻黄汤发汗。这就是“脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之”的意思；但若其人脉象并非阴阳俱紧，而是尺中脉迟，尺以候里，迟为营血涩滞不足之象，故为里虚之征。此属虚人外感，虽有表邪，亦当忌用汗法。否则，强发虚人之汗，犯了“夺汗者无血”的禁戒，将更伤营血而有劫阴之变。

许叔微《普济本事方》曾载一医案云：“昔有乡人丘生者病伤寒，予为诊视，发热头疼烦渴，脉虽浮数而无力，尺以下迟而弱。予曰：虽属麻黄证，而尺迟弱，仲景云，尺中迟者，荣气不足，血气微少，未可发汗。予与建中汤加当归黄芪令饮。翌日脉尚尔，其家煎迫，日夜督发汗药，言几不逊矣。予忍之，但只用建中调营而已。至五日，尺部方应，遂投麻黄汤，啜第二服，发狂，须臾稍定，略睡，已得汗矣。信知此事是难是难。仲景虽云不避晨夜，即宜便治。医者亦须顾其表里虚

实，待其时日，若不循次第，暂时得安，亏损五脏，以促寿限，何足贵也！”从这一医案可以看出，许氏对“虚人伤寒建其中”的原则是有深刻认识的。虽然后世对虚人外感的治疗方法有不少新的发展，如助阳解表、益气解表、滋阴解表等等，但对于虚人，在使用这些方剂发汗时，仍当谨慎为是。至于使用麻黄汤发汗，则更是绝对的禁忌。

脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。（52）

脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。（53）

【解析】这两条承接上条并与之对比，指出凡太阳表实证，非尺脉微、尺脉迟者，可以考虑用麻黄汤发汗。

浮脉主表，数有紧之意。从“可发汗，宜麻黄汤”看，其证当属太阳伤寒表实。表实应发汗以解表，用麻黄汤。但必须脉阴阳俱紧，方能投用。若尺脉微，尺脉迟，又当禁用汗法。故这里见浮脉，或脉浮而数，意在言外，则尺脉不微不迟，故“宜麻黄汤”，而不禁之。

病常自汗出者，此为荣气和。荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气和谐故尔。以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。（54）

【解析】本条论述荣卫不和，常自汗出的证治。

病，泛指已病之人，证见经常的自汗出，这是荣气无病而在外的卫气不与荣气相和谐的缘故。在正常的生理情况下，荣行脉中为卫之守，卫行脉外为荣之使，荣滋卫而使卫气不亢，卫护荣而使荣阴不泄。相互为用，相互制约。今因在外的卫气与荣气相离而不相将，卫气失却固外护荣之能，使荣气不能内守，故常自汗出。虽然荣气本身无病，但卫气不能固密，二者仍然不能互相协调，即所谓“以卫气不共荣气和谐故尔”。这种营卫不和的自汗出，可治以桂枝汤。因病本自汗出，而又用桂枝汤发汗，故谓“复发其汗”。桂枝汤有滋阴和阳，调和营卫的作用，用其发汗，可使营卫和合，卫外为固，荣阴内守，汗出自愈。此为发汗以止汗之法。

对本条荣卫不和的自汗证，注家有两种不同解释。一种意见认为，卫气不和的原因是受风邪所伤，用桂枝汤复发其汗，以祛风邪而和荣卫。另一种意见认为是荣卫本身失却协调，和风邪无干。根据条文，既未言太阳病，也不见寒热、头痛、脉浮之表证，故应以无太阳证的荣卫不和之说为妥。临床上，对于没有寒热、头痛等表证的自汗出病人，使用桂枝汤，每可取效，也是明证。

病人藏无他病，时发热，自汗出，而不愈者，此卫气不和也。先

其时发汗则愈，宜桂枝汤主之。（55）

【解析】本条论述卫气不和，时发热自汗出的证治。

“病人脏无他病”，是指饮食、二便、睡眠正常，无内证可述，说明里气和。而文中又未提太阳病或脉浮、恶风寒等表证，故知也非太阳中风。只是时而出现发热、汗出的症状，且缠绵不愈，他药无效。这也是卫气不和，荣卫失调的表现。荣与卫即阴与阳之属，阴不制阳，则卫阳亢而发热；阳不护阴，则荣阴外越而汗出。治疗也应选用桂枝汤调和荣卫。但一定要在发热汗出发作之前服药，因此时阴阳荣卫较为平衡稳定而易于调节，且可避免在发作时服药汗出太多而伤正。这类疾患，临床并不少见，尤以妇女更年期时更为多见，无论使用滋阴、助阳、清热、敛汗之法均难取效，若试用桂枝汤，则往往可以收功。

伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之。（56）

【解析】本条论述汗以代衄的证治，应与前47、48两条衄以代汗合参。

“伤寒脉浮紧”，指出证属太阳表实。“不发汗”一则指出病人无汗，一则意味着没有及时治疗或虽治而未用麻黄汤发汗。表证不得汗出，阳气被寒邪闭郁，其体质壮实者，就有邪从衄解的机转。如衄后脉静、热退身凉，病则愈，不必再汗。今虽衄而表不解，可能是虽衄而不畅，犹如发汗不彻一样，不足以解表达邪，因而起不到热随血减的作用。那么，为何衄而不畅？主要因为在经之邪太重而难出。此时当用麻黄汤发汗，以分消太阳经中之邪。汗出邪散，则鼻衄自止，热退病愈。因其仍需从汗而解，故属“汗以代衄”之法。

伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤。其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗；若头痛者必衄，宜桂枝汤。（57）

【解析】本条通过小便的清与赤以辨表里，并论述表里的不同证治。

“伤寒”在此泛指外感热病。在外感热病的发病过程中，六七日不大便，又见头痛有热。此处不具体说翕翕发热，还是蒸蒸发热，或是日晡潮热，是为进一步辨证留有余地。从“其小便清者知不在里”一句可知病仍在表，如头痛有热属于阳明里热上熏的，其小便必黄赤，其发热必蒸蒸或潮热，治疗自当用承气汤泻下。今小便清，则知里无燥热，病邪仍在于表，其证应头项痛、翕翕而热、恶风寒，尽管不大便六七日，因腹部无所苦，也不可泻下之法，可考虑选用桂枝汤发汗。“宜桂枝汤”，应接“当须发汗”之后。对于太阳经邪不解，头痛日久，阳郁过甚的病

人，也可以出现鼻衄代汗自解的情况。

《续名医类案》载李士材治一个患伤寒六日的病人，谵语狂笑，头痛有汗，大便不通，小便自利，众议承气汤下之。脉之，洪而大，因思仲景云：伤寒不大便六七日，头痛有热，小便清，知不在里，仍在表也。方今仲冬，宜与桂枝汤。众皆咋舌掩口，谤甚力，以谵语为阳盛，桂枝入口必毙矣。李曰：汗多神昏，故发谵妄，虽不大便，腹无所苦，和其营卫，必自愈矣。遂违众议用之。及夜，笑语皆止，明日大便自通。从这一病案看，谵语狂笑，头痛有汗，大便不通，均似阳明里热可下之证，然小便不短赤而自利，为里无热；脉不沉实而洪大，为里无实，腹无胀满疼痛之苦，为无可下之证。李士材抓住了以上辨证眼目，果断地使用桂枝汤调和营卫以解表，使病得以速愈，可以说是深得仲景的辨证要领，值得我们学习和效法。

伤寒发汗，解半日许，复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤主之。（58）

【解析】本条论述汗后余邪复聚的证治，可和第46条合参。

太阳伤寒表实证，经用麻黄汤发汗，汗后脉静身凉，说明表证已解。但仅仅半天左右的时间，又出现发热、脉浮数的证候。烦者，热也，脉浮数，即指浮紧而言，这仍是邪在外的表现。伤寒解后复见表证，此表邪由何而来？一般认为是汗后大邪已去，然余邪未尽，半日后又复聚为患。但也不排除复感风寒的可能性。无论余邪复聚或复感外寒，只要表证再现，则仍当再发汗解表，故曰“可更发汗”。然已经用过麻黄汤发汗，腠理已开，再不耐麻黄汤峻汗，故宜选用桂枝汤调和荣卫，解肌发表，祛邪而不伤正。此属一汗不解可以再汗之法。

凡病若发汗、若吐、若下、若亡（赵本有“血、亡”二字）津液，阴阳自和者，必自愈。（59）

【解析】本条指出，凡治病要求使人体达到阴阳自和则病必自愈。

“凡病”，泛指一切病证，不单指中风、伤寒。汗吐下用之得当，是为治病祛邪之法，可以调阴和阳，使阴阳调和而达到治愈的目的。但使用不当，又可损伤正气，如伤阴、伤阳、伤血、伤气等。若邪去而正衰，则不一定再用药物治疗，可以通过饮食调补、休息疗养，等待人体阴阳能以自我调节达到新的平衡，即可自愈。此即“于不治中治之”的方法。

昔年在营口学医时，邻人张某患伤寒日久，先后经几个医生治疗，

大病虽去，唯呃逆不止，久治不效。后延新民县某老医生诊治，问过病史后，嘱用粳米煮汤送服西洋参末二三分。服六七日，呃逆遂止。众医奇而问之，老医答曰：仲景说过，“凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。”此患者经治多日，邪气虽去，但胃中气阴已衰，而胃气不调作呃。如果再用药物去羁縻胃气，只能有害而无益。唯用米汤调养，借五谷之气以养人，实胜于药石，再加微量洋参以扶胃家气阴，效果更为理想。众医听后叹服不止。这位老医生的认识，可谓学有所得了。

本条明确说明，中医治病的目的就是要达到阴阳自和。既可通过药物治疗去达到这一目的，也可不用药物，通过自身机能的恢复与调节而达到这一目的。但绝不能盲目地滥用药物以破坏这一目的的实现，而违背医经之旨。

大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也，勿治之，得小便利，必自愈。（60）

【解析】本条举例说明阴阳自和必自愈。

表里同病，治当先解表后攻里，今先下后汗，为治疗失序。大下之后又发汗，而见小便不利，说明乃因汗下津伤所致，并非水饮内停。故不可见小便不利而误用渗利之品。这种情况当以饮食、水谷调养为主，待体内津液慢慢恢复，则小便必然通利，小便通利，反映了阴阳已经自和，故谓“得小便利，必自愈。”

本条告诉我们，临证时不要见小便不利就对证而利尿。若属亡津液的尿源不足之证，愈用渗利方药，则津液愈伤，而小便愈为不利。为此，可以通过饮食、水谷调养，滋其源而开其流，俾津液回生，化源充足，阴阳调和之时，则小便自然畅利。

下之后，复发汗，必振寒，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。（61）

【解析】本条论述误治伤阳，以致表里阳气皆虚的脉证。

下后复汗，治疗失序，邪气虽去，但正气已伤。“振寒”即寒冷而振栗，是表阳不足之证；“脉微细”是里阳虚衰之脉。病人经泻下与发汗后，出现表里阳气俱虚的脉证，故仲景断为“内外俱虚”之证。阳气之根本在于肾，少阴是一身阳气之总司。今表里内外阳气俱虚，实即少阴之阳已衰。

上条下后复汗而伤阴，本条下后复汗而伤阳。两条前后呼应，互相发明，以论证治疗不当，可导致伤阴、伤阳及阴阳失和的种种变证。

下之后，复发汗，昼日烦躁，不得眠，夜而安静，不呕不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。（62）

干姜附子汤方：

干姜一两 附子一枚生用，去皮，破八片

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

【解析】本条论述阳虚阴盛烦躁的证治。

凡表里同病之证，治应先汗后下为合法。今先下后汗，则属误治，病证不仅未愈，反使表里阳气俱伤。阳虚则阴盛，阴盛则来搏击弱阳，阴阳相争，则见烦躁不宁。阳王于昼，阴王于夜。白日人体之弱阳得天阳相助，能与阴争，故证见烦躁而不得眠，夜间阴气用事，弱阳无力与盛阴相抗衡，故夜而安静。烦躁本多属阳热之证，如太阳病有不汗出而烦躁或反烦不解；阳明病有大烦渴不解；少阳病有心烦喜呕。此处虽见昼日烦躁，但“不呕”则知非少阳病；“不渴”则知非阳明病；又“无表证”则知非太阳病，三阳无邪可言，而又见“沉微”之脉，沉主里病，微为阳衰，正是少阴真阳衰微，阴寒独盛之象，说明此昼日烦躁不得眠，属于阴证无疑。肾为阴阳之根，若阴盛阳衰至甚，则阳气难藏而有离根之险。根之虚阳外越，被逼于上为“戴阳”，被格于外为“格阳”，戴阳与格阳均是阳亡的先兆。戴阳于上，面红如妆；格阳于外，身大热而欲得近衣。本条言“身无大热者”，意即尚有微热，说明残存之阳幸而未尽外越。故以干姜、附子辛热纯剂，急煎顿服，力挽残阳于万一。

干姜附子汤由干姜、附子组成。姜、附大辛大热，以复先后天脾肾之阳。附子生用，力更峻猛。一次顿服，使药力集中，收效迅速。本方加甘草名四逆汤，加葱白名白通汤。此证因无阴盛阳郁之象，故不用白通汤；阴寒势甚，亡阳于顷刻，故当急温，迟则无及，故也不用四逆汤。本证阳气暴虚，阴寒独盛，寒极发躁，残阳欲亡，故舍甘草之恋缓，单取姜附之迅猛，急以扶阳抑阴为先。

发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。（63）

桂枝加芍药生姜人参新加汤方：

于桂枝汤方内，更加芍药、生姜各一两，人参三两，余依桂枝汤法服。

【解析】本条论述汗后营气不足的脉证与治法。

汗法本为表证而设。表证常见身疼痛，但汗后表解，身疼痛自应消失。本条言汗后仍有身疼痛，这是何原因？当须凭脉辨证。若脉浮，为表不解，可再发汗，今脉沉而迟，沉主里病，迟为血虚，说明此身疼痛，非为表证，乃发汗太过，损伤营气，以致不能营养四肢百骸所致。治当调补营卫，用桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤。

所谓“新加汤”，是指仲景在前人所创桂枝汤的基础上重用芍药生姜又加入参而成。由此可推知，《伤寒论》中113方，绝大多数是张仲景“博采”所得，而非其一人所首创。本方以桂枝汤调和营卫，加重白芍之量以养营血，加重生姜之量，使药力达表，专治营卫气血不足之身疼痛。如《金匱要略》中治“血痹”的黄芪桂枝五物汤，是桂枝汤去甘草加黄芪而成。本方生姜用量最大，恃其辛而外达，能领药力走表而治身疼，更加人参可补汗后之虚，亦以益气生津养营为之急务。

本方治营卫气血不足的身疼痛效果很好。曾治一妇女，产后半月，患身疼不休之证，服过生化汤未取效。实习学生曾与八珍汤等，虽见小效而不能根治。诊之，六脉无力，遂用新加汤原方，服用三剂，竟获痊愈。

发汗后，不可更行桂枝汤。汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤主之。（64）

麻黄杏仁甘草石膏汤方：

麻黄四两，去节 杏仁五十个，去皮尖 甘草二两，炙 石膏半斤，碎，绵裹
上四味，以水七升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。本云：黄耳杯。

【解析】本条论述邪热壅肺作喘的证治。

风寒在表，发汗可解。但当外邪闭郁，肺有蕴热之时，若用辛温发汗，则常易使肺热加重。邪热迫肺，肺失清肃，故见喘息。肺热蒸腾，逼迫津液外泄，故见汗出。由此，汗出而喘便成为肺热的明证。此证汗出而喘，但不恶风寒，是表无寒邪，所以“不可更行桂枝汤”；汗出而喘，并非“无汗而喘”，故也不可用麻黄汤，这就把太阳病表证之喘排除

在外。汗出而喘，身“无大热”，也无烦渴之证，又把阳明内热上迫于肺之喘也排除在外。但也有注家把“无大热”做无太阳病表证来解亦通。据临床观察，本证由于邪热在肺作喘，肺合卫而主皮毛，常常可见到发热，甚至高热不退，故不可被“无大热”一语所惑。麻黄汤证的无汗而喘，桂枝加厚朴杏子汤证的有汗而喘，均为太阳之邪影响肺气宣降所致。本证则是邪热壅肺，肺失清肃而作喘，与风寒无干。故治疗重点在于清肺热，而不在于发汗解表，因而用麻杏甘膏汤治之。

麻杏甘膏汤由麻黄、杏仁、甘草、石膏四药组成，全方以清肺热、平喘为主。方中麻黄不配姜桂，则并不发汗，而功在宣肺平喘。无论寒喘、热喘，只要配伍得宜，此药均可使用。本方则以其配石膏，清宣肺中郁热，用于治疗热喘有效。石膏剂量用至半斤，它超过麻黄用量的一倍，其清肺热的效能则显而易见；杏仁降肺气之逆，佐麻黄以平喘咳；甘草调和诸药，补中益气。

临床用本方治疗肺热作喘疗效甚佳，尤其对小儿麻疹并发肺炎而属于肺热者，更有可靠的疗效。根据临床经验，肺热重者，可加羚羊角粉；痰热壅盛，痰鸣气促者，可加黛蛤散或鲜枇杷叶；喘而大便不下者，加瓜蒌皮、炙桑皮；大便燥结者，可加大黄，俾下窍通则上窍利而喘则愈；若麻疹不透，疹毒内陷，以致喘促不安、鼻翼扇动，唇甲紫绀，可用五虎汤，即麻杏甘膏汤加上等好茶叶，同时用三棱针点刺耳背紫色络脉出血，每可取效；若肺气不利，憋气胸闷者，还可加甜葶苈以泻痰热。总之，只要能随证加减化裁，多能获得良好的治疗效果。

发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。（65）

桂枝甘草汤方：

桂枝四两，去皮 甘草二两，炙

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

【解析】本条论述心阳不足而致心悸的证治。

汗为心之液，由阳气蒸化津液而成，即所谓“阳加于阴谓之汗”。所以过汗必然要耗伤心阳，心阳被伤，使心失去了阳气的庇护，则空虚无主，故见心中悸动而又喜按，借以安定心悸之苦，此乃外有所护则内有所恃之故。所谓“其人叉手自冒心，心下悸，欲得按”是矣。据临床观察，此类患者可见到心前区憋闷不适等证。治用桂枝甘草汤调补心阳则愈。

桂枝甘草汤仅桂枝、甘草二药。桂枝辛甘以补心阳，甘草甘温以滋心液，且二药相合，辛甘合化为阳，又以补阳为主，阳生阴化以奉于心。心阳得充，则悸动自安。桂枝去芍药汤治太阳病下之后脉促、胸满之证，用生姜、大枣，则有调和荣卫之意；本方单用辛甘合化助阳而不用生姜、大枣，是使药专力锐，直接抵达病所之意。虽然临床有时亦可见到胸满一证，但属阳虚不运，非为邪气干扰，故治疗只宜温补心阳。

发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

（66）

茯苓桂枝甘草大枣汤方：

茯苓半斤 甘草二两，炙 大枣十五枚，擘 桂枝四两，去皮

上四味，以甘烂水一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。作甘烂水法，取水二斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。

【解析】本条论述心阳不足，镇摄无权，欲作奔豚的证治。

“奔豚”是一个证候名。《金匱要略·奔豚气病脉证治》指出：“奔豚病从少腹起，上冲咽喉，发作欲死，复还止”，基本描述了此证的主要临床表现。病人自觉有气由下向上游走，如豚之奔，其气所过之处，便

出现许多症状。如气至胃脘则感胀满；至胸部则感胸闷心悸；至咽喉，则感憋闷窒息欲死，甚至冷汗淋漓。有的还可上冲至头部而眩晕欲仆地。气下则诸证尽消失。时发时止，呈阵发性发作，间歇期多无所苦。其病因多为中、上焦阳气不足，下焦水寒之气上犯，即水来克火，阴来搏阳所致。所谓“豚”，即指小猪。以豚命名，一则以喻气之上冲有如小猪奔跑，一则因豚为水畜，借以比喻水气上冲为患。因其常突然发作，故又有“贲豚”之称，比喻其气上冲如怒豚之奔。脐下悸是奔豚病发作的前驱症状，故叫“欲作奔豚”，是水与气相搏于脐下，欲上冲而未冲之证。在生理情况下，心为五脏六腑之大主，为阳中之太阳，坐镇于上，普照于下，使下焦水气安伏不动。脾为中土，运化水湿，如堤坝之居中，可保护心阳不被下焦水寒之气所犯。若过汗伤损心脾之阳，或素体心脾阳虚，则心阳不能坐镇于上，脾土不能守护于中，下焦水寒之气就可能蠢蠢欲动，乘机上干而表现为脐下悸动。此时应治以苓桂枣甘汤以温阳伐水降冲，而防患于未然。

茯苓桂枝甘草大枣汤方，用桂枝甘草辛甘合化为阳以补心阳之虚；茯苓甘淡，健脾气，固堤坝，利水邪，行津液，且可安魂魄以养心神。其量用至半斤，而又将其先煎，目的在于增强健脾利水的作用，以制水于下。大枣健脾补中，使中焦气实，则堤坝自固，以防水气泛于上。本病属于水气为患，用甘烂水而不用普通水煎药，乃是恐有助邪之弊。甘烂水，也叫“甘^泔水”或“劳水”，考《内经》半夏秫米汤即用此水煎药，则其意可见。

发汗后，腹胀满者，厚朴生姜甘草半夏人参汤主之。（67）

厚朴生姜甘草半夏人参汤方：

厚朴半斤，去皮，炙 生姜半斤，切 半夏半斤，洗 人参一两 甘草二两，炙

上五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【解析】疔，终使胀满得以缓解。在使用本方时，应注意厚朴、生姜要等量且用量要大，参草用量宜小，反之则胀满难除。

伤寒若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。（68）

茯苓桂枝白术甘草汤方：

茯苓四两 桂枝三两，去皮 白术二两 甘草二两，炙
上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

【解析】本条论述水气上冲的证治。

太阳伤寒，本应汗解而反用吐下，使中、上焦阳气受伤，形成心脾阳气虚而水气上冲的证候。“心下逆满”，指胃脘部因气上逆而感觉胀满，同时还有“气上冲胸”的感觉。气上冲一证，临床上还可以见到冲至咽喉部而有憋气、窒息之感者。如在京西城子煤矿带学生实习时，同学接诊一老妇人，主诉咽中似有一物堵塞，吐之不出，咽之不下，据病情投以四七汤，连服几剂并未见效。观其舌苔水滑，六脉俱弦，其证尚有气上冲之感，待气冲至咽喉部时，则觉堵闷特甚且有心慌、心跳等证。遂断为水气上冲，换用苓桂术甘汤，仅服一剂即见效。临床上类似病例并不少见，只不过这一例较为典型而已。“起则头眩”，是指病人头晕很厉害，只能静卧而不敢起动。造成眩晕的原因有两个：一是心脾阳虚，清阳之气不足以上养清窍；一是水气上冲，阴来搏阳，清阳被水寒之气所冒蔽。“脉沉紧”即沉弦之意。沉主里，又主水病，弦主饮邪，沉弦正是水气为患的脉象。从以上脉证可知，伤寒经吐下后，病已离表，当然也不能再用汗法解表。若再行解表发汗，则可能动伤经脉之气，即“发汗则动经”，使阳气更虚，不能荣养筋脉，则“身为振振摇”，即肢体战振摇动，甚则站立不稳而欲仆。治宜温阳健脾，降冲利水之法，轻者用苓桂术甘汤，阳虚者用真武汤。

茯苓桂枝白术甘草汤是苓桂剂群的代表，善治水气上冲，又治痰饮内留等证。方中苓术健脾利水，桂枝甘草补心阳之虚，且桂枝又善降冲逆之气。此方在临床若灵活加减，则十分好用：如痰湿特盛者，可与二陈汤合方使用；眩晕重者，可加泽泻；兼见面热、心烦者，为阳气与水气相搏而有虚热的表现，可加白薇；兼血压高者，可加牛膝、红花、茜草；兼见脉结代者，去白术加五味子；兼咳喘、面目浮肿、小便不利者，去白术加杏仁，或薏苡仁；兼夜寐惊悸不安者，加龙骨、牡蛎等等。

本方温中降逆，其所治之证以气上冲逆为主。有的注家认为，水邪本属阴，其性沉降，本不应冲逆上乘，而若见心下逆满、气上冲胸、心悸、头眩等上冲之证，则多与挟肝气上逆有关。桂枝辛温芳香，既可温通心阳，又可舒肝降气，治水气上冲在所必用。本论第29条亦为水饮之

证，但其仅见“心下满”，而并非“心下逆满”，因无上冲证候，故方用桂枝去桂加苓术汤。可见均属水饮为患，其治用桂与去桂，关键在于有无上冲之证。

发汗，病不解，反恶寒者，虚故也，芍药甘草附子汤主之。
(69)

芍药甘草附子汤方：

芍药三两 甘草三两，炙 附子一枚，炮，去皮，破八片

已上三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分温服，疑非仲景意。

【解析】本条论述汗后阴阳两虚的证治。

文中虽未明言起于何病，但从治以汗法来看，可能原为太阳表证。既为表证，当有恶寒之证，然汗后表解，恶寒当罢。今汗后恶寒反而加重，且不见发热，可知恶寒并非表不解，而是病情变为正虚，“反恶寒者，虚故也”一语，就是对正虚病机变化的概括。本条述证简单，以方测证可见这里的“虚”是指阴阳两虚。阳虚不能温煦肌表，故恶寒反剧；阴虚不足以濡润筋脉，似当有肢挛急之变。夫表证去而转为里虚，故脉不应浮而当见沉迟细弱之象。治以芍药甘草附子汤，扶阳益阴，而达阴阳两顾。

本方芍药味酸微苦以滋营阴，甘草甘温和中缓急，二药相伍，使酸甘合化，以益阴养营。附子辛热扶阳实卫，合甘草则增强辛甘化阳之力。全方共奏阴阳双补之功。本方药少而专，丝丝入扣，可谓组方遣药之楷范。

发汗若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。(70)

茯苓四逆汤方：

茯苓六两 人参一两 甘草二两，炙 干姜一两半 附子一枚，生用，去皮，破八片

上五味，以水五升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

【解析】本条论述汗下后致阴阳两虚而烦躁的证治。

发汗太过则伤阳，泻下不当则伤阴，先汗而后下，则阴阳两伤。“病仍不解”，非指太阳表证不解，乃是指治不得法，使病情发生变化而未能得愈。太阳与少阴为表里，误治太阳，则可虚其少阴。少阴为水火之脏，阴阳之根。阴阳两伤，水火失济，故见昼夜烦躁不宁。因以少阴阳虚为主，所以伴见恶寒、厥逆、脉微细等证。治以茯苓四逆汤扶阳兼以救阴。

茯苓四逆汤由茯苓、人参、生附子、炙甘草、干姜组成。方用姜附温经以回阳，人参益气生津以救阴，茯苓宁心安神，甘草和中。《神农本草经》谓：“人参味甘微寒，主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸”；茯苓主“忧恚、惊邪、恐悸……久服安魂养神。”这说明参、苓均有较好的宁心安神的治疗作用。从药味组成看，本方即四逆加人参汤另加茯苓。本论《辨霍乱病脉证并治法》谓：“恶寒脉微而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之”，这里的“亡血”指因下利而致的阴液下亡之义，其病情由阳虚发展到津伤液耗，是毋庸置疑的。柯韵伯在《伤寒附翼》中，通过比较茯苓四逆汤和干姜附子汤的证治，对本方的治疗作了很好地说明：“先汗后下，于法为顺，而表仍不解，是妄下亡阴，阴阳俱虚而烦躁也，故制茯苓四逆，固阴以收阳。先下后汗，于法为逆，而表证反解，内不呕渴，似于阴阳自和，而实妄汗亡阳，所以虚阳扰于阳分，昼则烦躁也。故专用干姜附子，固阳以配阴。二方皆从四逆加减，而有救阳救阴之异。”

发汗后，恶寒者，虚故也；不恶寒，但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。（71）

【解析】本条通过对汗后所发生的虚实两种不同病证的对比，进而说明邪气从化有寒热，人体病变分虚实的辨证方法。

既用发汗之法，可知其原来必有表邪。但若汗不得法，而致表邪不解，则可因病人素体阴阳盛衰的不同而从化也各异。若汗出后证见恶寒者，多为素体阳虚，汗后阳气更伤，温煦失职，证已转虚，似属芍药甘草附子汤证。若汗出后“不恶寒，但热者”，反映邪气已离开太阳之表，但又未入三阴之里，多为素体胃阴不足，汗后胃津更伤，邪从燥化，已转属阳明病之胃家实证。阳明之热从里向外发越，应见犹如炊笼热气外腾的“蒸蒸发热”，以及谵语等证。但因燥热初结阳明，在于胃而未下达于肠，故不见痞、满、腹痛诸证，治用调胃承气汤泄热以和胃即可。

太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，与五

苓散主之。（72）

五苓散方：

猪苓十八铢，去皮 泽泻一两六铢半 茯苓十八铢 桂（赵本有“枝”字）半两，
去皮 白术十八铢

上五味为末，以白饮和，服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈。

【解析】本条论述汗出津伤与太阳蓄水证的证治。

足太阳之腑为膀胱。膀胱本寒而标热，在生理上为寒水之腑，故在病理每多水证之变。本条前半段叙述汗后津伤，胃中干而见口渴，烦躁不得眠之证，乃假宾以定主。重点在后半段论述汗后气伤，致使膀胱蓄水，而见烦渴之证治。两证虽都有口渴见证，但病机不同，治法各异，并列论述，以资鉴别。

发汗后以致大汗出，是汗不得法，必然伤津，而使胃中津液亏乏。阴虚则阳盛，津亏则气燥，阳盛气燥，阳明不和，则心神不宁而烦躁不得眠。津乏于内，必求助于外，故口渴欲得饮水。证轻者，可嘱病人少少地饮水，使津液慢慢地恢复，待胃气自然调和，则不药而愈。在汗后津伤气耗之余，胃气弱而不行，切忌暴饮而图快于一时，以免导致胃中停饮。若胃中燥热较甚，用上法而不解者，可酌与白虎汤或白虎加人参汤以清热生津。

若在大汗出后，脉仍浮且身有微热，此为太阳经表之邪未解。而又见“小便不利”、“消渴”，则为太阳膀胱腑气不利。由于经脉络属于脏腑，故太阳经邪不解，又经大汗伤正，表邪则很容易由经内并于腑，而影响膀胱气化功能。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出。膀胱气化不利，津液不行，水蓄于下，则小便不利；津液不能气化以上承，则渴欲饮水。但饮水后却因气化不利、津液不行而不能解渴，因此形成所谓“消渴”，这是与上述胃燥津伤轻证，少少与饮之即可使口渴缓解的不同之处。本证之“消渴”，渴而能饮，但小便不利，这与杂病中饮多溲多之消渴病也不相同。总之，本证外有太阳表邪，内有膀胱蓄水，故用五苓散外疏内利，表里两解。

五苓散中以猪苓、茯苓、泽泻淡渗利水以利小便；白术助脾气之转输，使水精得以四布；桂枝辛温，通阳化气而解肌祛风。“以白饮和”服，含有服桂枝汤啜粥之义；“多饮暖水”，可助药力以行津液而散

表邪。本方通阳化气以利水道，外窍得通则下窍亦利，故曰“汗出愈”。若只是膀胱气化不利的蓄水证而不兼表证者，也可使用本方治疗，此时或用肉桂取代桂枝，取其温阳消阴以行气化之力。总之，本方可通过利下窍而达到利三焦、健脾气、降肺气的治疗目的，正如前人所说，可通行津液，克伐水邪，以行制节之令。方用散剂服用，散者散也，取其迅速发散之意。

“方寸匕”，是古代量药的器具，呈正方形，有柄，因其边长一寸，故名“方寸”，用其量药，以不落为度，约合今之10克。

本方临床应用较广。除《伤寒论》中用其利水行津液以治太阳膀胱蓄水外，《金匱要略·黄疸病脉证并治》用本方加茵陈名茵陈五苓散，治湿邪内郁之发黄证，以五苓渗利湿邪；《博文类纂》还用本方治风湿疫气，书中说：“春夏与夏秋之交，淋雨天热，地气蒸郁，湿气太盛使人发病，头痛，壮热，呕逆，一家之病曰风湿瘟疫，用五苓散加生姜大枣可治。”其他著作也有类似记载。

临床经验证明，本方略加化裁变通，或与他方合用，即可治疗多种水湿蕴郁的病证：如湿郁兼热，证见小便不利，烦热而渴者，可用桂苓甘露饮，即五苓散加三石（寒水石、滑石、生石膏）而成；高年体弱，正气不足，中气虚衰，心功能不全而小便不利者，可用本方去桂枝加肉桂、人参，名春泽煎，有强心利尿，补虚益气之效；对素喜厚味酒醴，久而生湿，湿浊内蕴，以致胃脘胀满，气闷不畅，小便不利，舌苔厚腻，脉弦滑者，可以本方与平胃散合用，名胃苓汤，有渗湿和胃，消导宽中之功；若素体阳虚，寒湿内生，证见腰腿发凉，两足发冷，腰腿酸重，小便不利，可用本方加苍术、附子，名苍附五苓散，有温阳祛湿与逐水之功。随证化裁，每多收效。

曾治一素嗜浓茶的患者，吐痰特多。先用二陈汤，虽有小效，但不能根治，考虑脾为生痰之源，肺为贮痰之器，遂加用五苓散以健脾通阳，渗利水湿，药后尿量增加而吐痰明显减少。足见脾湿去则痰不生的意义。

发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。（73）

【解析】本条承上条补述五苓散的脉证。

太阳病发汗后，表邪不尽，所以脉见浮数。表邪随经入里，膀胱气化失司，下焦蓄水，津液不能上滋，所以心烦、口渴。“烦渴”亦有解为渴甚的。然既为太阳膀胱蓄水，故必见小便不利之主证。其治仍以五苓散解表而利水。

伤寒汗出而渴者，五苓散主之。不渴者，茯苓甘草汤主之。
(74)

茯苓甘草汤方：

茯苓二两 桂枝二两，去皮 生姜三两，切 甘草一两，炙
上四味，以水四升，煮取二升，去滓，分温三服。

【解析】本条以对比鉴别的方法，论述膀胱蓄水与胃脘停水证治之不同。

从“汗出而渴者，五苓散主之”，可知证属汗后太阳之气被伤，膀胱气化不利，水蓄下焦，津液不能输布上承，故必见口渴、小便不利之证，应治以五苓散。若汗后胃阳被伤，胃失腐熟之权，以致水停中焦，则因其无关下焦气化，故口不渴而小便自利，治应以茯苓甘草汤温胃化饮，以安心下之悸。

五苓散证与茯苓甘草汤证，皆为蓄水证，但在病机方面，有水蓄下焦和水停中焦的不同；在证候方面有口渴与不渴，小便不利与小便自利的区别；二者证治不可混淆。唯本条茯苓甘草汤证叙述过简，难于辨认，与原文第370条“伤寒厥而心下悸者，宜先治水，当服茯苓甘草汤”合参，可知此证当有“心下悸”。临床推按此类病人的上腹部，可听到震水音者，则更可确认。

茯苓甘草汤由茯苓、桂枝、生姜、甘草组成，与前述苓桂术甘汤仅白术一药之差，但其主治却有所不同。本证为水渍入胃，阻遏清阳不伸，故以脘痞、厥而心下悸为主证；苓桂术甘汤证则是心脾两虚，不能镇水于下，水气上冲，故以心下逆满、气上冲胸、头眩、心悸为主证。本方用生姜意在温胃通阳以散水邪，用时应注意生姜剂量，一般以12克至15克为宜。由于胃脘停水不易速消，故可连续多服几剂，或与健脾的方药交替服用，才可使疗效提高并得以巩固。

中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆。五苓散主之。(75)

【解析】本条论述太阳蓄水而致“水逆”的证治。

太阳中风，寒热、头痛，六七日表不解，邪气随经入腑，以致经腑俱病，故称“有表里证”。口渴能饮，饮不解渴，即所谓消渴，是太阳蓄水见证之一。若口渴能饮，水入则吐，吐后仍渴，再饮再吐，则称

为“水逆”。水逆即水邪上逆作吐之意。其临床表现特点是饮水即吐，进食却不吐，一般吐水而不吐食。且病因非痰、非火、非食、非郁、非寒，而是由水邪上逆而致，故以“水逆”命名。由于此证为水蓄膀胱，气化不行，所以在渴饮的同时必见小便不利一证。此证水遏于下而气化不利，由下上迫于胃，使胃气不降则吐水；津不上承，则口渴不止，从而形成再饮再吐，而渴仍不解之证。吐水而饮不解，我们简称之谓“水吐”。此种蓄水病证，治疗用五苓散解表利水，俾小便利，则气化行，津液通达，胃气因和，而口渴自止，水逆自愈。

本条可以给我们这样的启示：水性润下，火性炎上，这是事物的普遍性。但当膀胱蓄水，小便不利，下窍不通之时，水邪也可犯于上而发生种种上逆的病证，这又是事物的特殊性。水邪上逆，不但可形成水逆证；若影响肺气不降，也可见胸闷而喘；影响头目清阳之气不利，还可见到眩晕。证候虽异，而原因却同。《金匮要略》用五苓散所治之癫痫，就是水邪上逆，冒蔽清阳所致。

曾治河北晋县一王姓男青年，患癫痫，虽屡用苯妥英钠等抗癫痫药物，不能控制发作。自述发病前感觉有一股气从下往上冲逆，至胃则呕，至心胸则烦乱不堪，至头则晕厥，人事不知，少顷则苏醒。小便频数，但排尿不畅，尿量甚少。脉沉滑，舌质淡嫩，苔白。遂辨为太阳膀胱蓄水，水气上逆，冒蔽清阳之证。拟利水、通阳、温养心肾之法。方用：泽泻18克、茯苓12克、猪苓10克、白术10克、肉桂3克、桂枝10克。连服九剂，癫痫发作竟得以控制。临床实践证明，对于阳虚水泛型的癫痫病，有时亦可用真武汤治疗，或五苓散与真武汤合方使用，皆有良好的疗效。

未持脉时，病人手叉自冒心，师因教试令咳而不咳者，此必两耳聋无闻也。所以然者，以重发汗，虚故如此。（76）

【解析】本条论述重发汗以致心肾阳虚的证候。

“病人手叉自冒心”，是形容病人以双手护持于心前区的表现，凡有所冒，必有所苦，据情可知患者当有心悸一证。然心悸有虚、实之异，凡实者，必自护而拒按；凡虚者，则喜按而使悸动减缓。本证属虚、属实，尚须作进一步诊断。医生遂嘱病人咳嗽，若病人毫无反应，说明其人“耳聋无闻”。况又见于重发汗之后，故属虚证无疑。因汗出太多，伤及心阳，则心悸而“手叉自冒心”；伤及肾气，肾开窍于耳，肾气虚则“必两耳聋无闻也”。由于造成心肾两虚、心悸、耳聋的原因，是发汗太重或多次发汗的结果，故云“所以然者，以重发汗，虚故如此。”

耳聋一证，临床也有虚实之别。正虚耳聋，除本条所述过汗伤及肾

气所致者外，尚有老年人及大病之后，精气虚衰，耳窍失养之耳聋，也属正虚范畴。实证耳聋，多为少阳经脉受邪，经气不利所致，其特点常是暴聋，且有堵塞闭胀之感，与虚性耳聋无堵胀感者自不相同。

发汗后，饮水多，必喘，以水灌之，亦喘。（77）

【解析】本条论述汗后正虚，水寒伤肺而致喘。

不当汗而汗，或发汗太多，必然伤耗人体的阴精和阳气。若发汗后胃中气液受损而见口渴者，当少少与饮之，以和胃气则愈。切忌暴饮多饮，以免气虚不足以运化，造成水饮停聚之患。肺脉起于中焦，下络大肠，还循胃口，上属于肺。水饮之邪循经上迫于肺，使肺气不降则作喘。“以水灌之”，即用水浴身。汗后正虚，又以冷水沐浴，肺合皮毛，外窍受寒，内舍于肺，肺失宣降，亦可致喘。此即“形寒饮冷则伤肺”之意。以水灌之为形寒，饮水过多为饮冷，伤于肺使肺气不利则生喘疾。由此可以推知，凡人体正气不足之时，特别是大病之后，一定要注意调养护理，既要预防外邪侵袭，又要注意饮食起居，不可暴饮暴食，否则仍会发生他病。

发汗后，水药不得入口为逆，若更发汗，必吐下不止。（78）

【解析】本条论述因于误汗以致发生吐下不止的变证。

发汗后致使水药不得入口，可知发汗不当而使胃气受伤，这种治疗上的错误，是不顺于理的，故曰“为逆”。若再发汗，则为一逆再逆，必更伤中阳。伤于胃的反应是呕吐不止，伤于脾的反应是下利不止。可见治法若使用不当，不仅不能愈病，反而使病情加重，故临床不可不慎。

发汗吐下后，虚烦不得眠；若剧者，必反复颠倒，心中懊^懔，栀子豉汤主之。（79）

梔子豉汤方：

梔子十四枚，擘 香豉四合，绵裹

上二味，以水四升，先煮梔子，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服，得吐者，止后服。

【解析】本条论述热扰胸膈的证治。

邪在表宜汗，在胸当吐，在腹应下。故汗吐下均为邪实而设。今汗、吐、下后而见心烦不得眠，说明实邪虽去但余热未尽而内蕴。表邪入里有多种途径，其证候表现亦有多种形式。从前文所涉及的，有邪传阳明表现为白虎汤证者；有邪传少阳，表现为小柴胡汤证者；亦有太阳本经传入本腑，表现为五苓散证者。本条所论，则是余邪未尽，化热入里，郁于胸膈不解。太阳受气于胸中，胸与表为近邻，故有“邪气传里必先胸”之说。本论第23条有“太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之”，讲的是太阳误下，寒邪留于胸中，而阳气被抑；本条则论发汗吐下后，余邪未尽，化热入于胸膈。二者虽有寒热之异，但病位俱在胸膈却相同。

“虚烦”，是一个证候名称。烦者，热也，指病因为热邪而生；烦者，心烦也，指病证为热扰于心而致。因此，“烦”字既包含了病因，也包含了主证，即因热致烦之意。“烦”字之前冠以“虚”字借以说明病变性质，且有鉴别诊断的意义。此“虚”非指正气之“虚”，乃是与有形之“实”邪相对而言。表邪入里，若与有形之物，如水、痰饮、宿食等相互搏结，则形成实证，如热邪与痰水相结的结胸证及热邪与宿食燥屎相结的阳明腑实证等，均有心中懊恼或烦躁的见证，乃是实性之烦，而非虚烦；而本条之烦，虽也因于热邪内陷，但并未与有形之物相结，无物与之攀缘，只是无形之邪热留扰胸膈而蕴郁上焦，故称“虚烦”。也有的注家认为，本证乃因汗吐下后正气乍虚，邪热内郁所致，故谓“虚烦”，然既为正虚，为何不用补药？可见正气乍虚之说，并不妥当。

虚烦虽无实邪，但却有火热之郁，故又可称为“郁烦”，它与一般的火热证，如心火、肺火、肝火等的不同之处，在于它不仅火热，而且有郁遏。火热之邪蕴郁胸膈，不得伸展宣泄，因而致烦。其轻者，心烦不得眠；其重者，“必反复颠倒，心中懊恼。”懊恼，形容心中烦乱特甚，而有无可奈何之状。刘河间在《伤寒直格》中，将此比喻为像吃了

巴豆或草乌头后那样的心里难受，足见“郁烦”之痛苦已非一般了。火郁当清之、发之，故用栀子豉汤清宣郁热以除烦。

本方由栀子、豆豉二药组成。栀子苦寒，可导火热下行，且因其体轻上浮，清中有宣，故与芩连之苦降直折不同。豆豉气味轻薄，既能解表宣热，又可和降胃气，宣中而有降。二药相伍，既可清解胸表之热，又可宣泄火郁之烦，还可调理气机之升降出入，对火郁虚烦之证疗效颇佳。

使用本方，定要先煎栀子取其味，后纳豆豉取其气。原文方后有“得吐者止后服”一句，验之临床，也有吐的，也有不吐的，因此不可拘泥。记得昔年行医时，曾诊一王姓亲戚患伤寒发热，数日后见心中懊恼，坐卧不安之证。患者心烦难耐，甚至家人近前也遭憎厌呵斥。查其脉数、舌红、苔黄，遂断为火郁虚烦证。与栀子豉汤原方服用，但对药后作吐的反应未向病家交代。当晚，患者药后作吐，家人惊恐，疑是方药有误，复邀诊视，见患者吐后已安睡。经说明情况，家人始得放心。记述此案，一则说明服本方后确有吐者，一则也提示医者，用此方时，应事先向患者交代服药后的反应，以免引起不必要的惊恐。其实，栀子与豆豉并非催吐药，但为什么有时在药后可以吐呢？从本证病情特点看，这种吐是属正气驱邪外出的表现。因其火郁于胸膈，胸阳被困，药后火郁得宣，正气得伸，正胜邪而驱邪外出，故有吐而作解的机转。一般来说，郁烦懊恼越严重，火郁越甚，正邪交争越激烈，药后得吐的机会亦越多。这种邪郁胸膈得吐而愈与邪在肠胃作泻而解的机理相同，也可以说是《内经》关于“其高者引而越之，其在下者引而竭之”的论治法则的具体体现。但在临床上，用本方后出现得吐而解的机会也并不普遍。不见吐而使火郁得泄、心烦得除者，亦往往有之。如《伤寒明条》中即认为，服栀子豉汤后不会致吐，主张把原文“得吐者止后服”改为“得汗者止后服”。其理由是，本方为清宣之剂，豆豉又有解表之力，故可得汗而解。此说亦可供参考。

后世医家根据张仲景用栀子开火郁治虚烦的道理，不断扩大了栀子治疗诸郁证的应用范围，并取得了较好的疗效。如治疗肝气郁、血虚生热的八味逍遥散证，就是在逍遥散舒肝健脾养血的基础上，又加入丹皮、栀子，以清宣郁热为主；又如朱丹溪所用的越鞠丸，治疗气、血、痰、火、湿、食等六种郁证，其中即有栀子，以治疗火郁为主。

若少气者，栀子甘草豉汤主之。若呕者，栀子生姜豉汤主之。

梔子甘草豉汤方：

于梔子豉汤方内，加入甘草二两，余依前法。得吐，止后服。

梔子生姜豉汤方：

于梔子豉汤方内，加生姜五两，余依前法。得吐，止后服。

【解析】本条论述虚烦兼少气或呕吐的证治。

少气是邪热伤气的表现，胸为气海，火郁于胸膈极易伤气，气虚则见少气。少气与短气不同，少气是呼吸低弱，自觉气不够用；短气是呼吸促迫，似有所阻。故一般认为少气属虚，短气属实。火热伤气，治应泻火、补气。然补气药中参芪温补，难以选用，唯甘草味甘性平而和缓，益气缓急且不助烦热，再配梔、豉清宣郁热，方与证情相宜。

热能耗气，亦可动饮。《医宗金鉴》认为，热邪迫胃，饮气上逆，可以致呕。本条之“呕”，即是郁热迫胃气挟饮气上逆所致。故在梔子豉汤的基础上加用生姜降逆止呕，和胃散饮，并协同梔、豉宣泄火郁之邪。在此不选半夏止呕，可能是因其温燥而不利于火郁之证的缘故。

从以上三方的配伍选药可以看出，仲景开火郁，不用黄连用梔子；治少气不用参、芪用甘草；止呕吐不用半夏用生姜，足见其制方用药之严谨，这是值得我们很好地学习和借鉴的。

发汗、若下之而烦热，胸中窒者，梔子豉汤主之。（81）

【解析】本条论述火郁影响气分而见胸中窒塞的证治。

心主血，肺主气，二者同居胸中。火郁胸膈，既可影响气分不和，亦可影响血分不利。本条所论则是火郁之邪使胸中气机不畅而见“烦热，胸中窒”的证候。“烦热”，或谓心烦、身热；或谓因热而烦，心烦特甚，二说皆通。窒者，塞也。“胸中窒”，指胸部有堵塞憋闷不畅快之感。本证是在前述虚烦不得眠的证候基础上出现的，因其仅觉窒塞而无疼痛，说明火郁所及，只在气分而尚未影响血分。治则仍用梔子豉汤清散火郁。火郁得宣，则气机自然畅达，其证自会迎刃而解，故不必加用枳壳、香附一类理气之药。

伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也，梔子豉汤主之。（82）

【解析】本条论述火郁影响血分而见心中结痛的证治。

“伤寒五六日，大下之后，身热不去”，而不见恶寒，说明邪已化热，与伤寒表证初起不同。以方测证，可知表邪已化热入里。火热郁于胸膈，必有心烦懊_忪等证。然本证火郁所及，不仅影响气分不和，而且进而影响血脉不利。心主血脉，不通则痛，故见“心中结痛”之证。“心中结痛”较“胸中窒”之证更为深重。因其病因仍是火郁，故仍用栀子豉汤治疗，不必再加丹参、郁金等活血化瘀药物。由此联系到《医宗金鉴》所载之“截法”治疗心痛，方用栀子、乌头二药，偏热者重用栀子，偏寒者重用乌头，以及伤科常用栀子泡黄酒外搓筋肉，以消瘀止痛等方法，均说明栀子除清热泻火的疗效外，还具有调理血脉的作用。

伤寒下后，心烦，腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。（83）

栀子厚朴汤方：

栀子十四枚，擘 厚朴四两，姜炙 枳实四枚，水浸，去穰，炒

已上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服。温进一服，得吐者，止后服。

【解析】本条论述虚烦兼腹满证治。

“心烦”、“卧起不安”与“心烦”、“反复颠倒”词异而义同。“腹满”即腹胀。伤寒见心烦、腹满，当认真辨证。若腹满而痛、大便秘结者，多属阳明腑实；若腹满不痛，二便尚调，则多属气机壅滞。本条为“伤寒下后”之证，可知表邪已化热入里。火郁胸膈则心烦、卧起不安；热及脘腹，气机被郁，而见腹满。但其热并未与有形之物相结，仅是无形之热蕴郁胸腹，故治以栀子厚朴汤清热宣郁，利气消满。

栀子厚朴汤即小承气汤去大黄加栀子而成，亦可以看做是栀子豉汤与小承气汤化裁的合方。因其腹满仅是气滞而无腑实，故不用大黄泻下；又因其表邪已化热入里，迫及脘腹，故不用豆豉之宣透。方用栀子清热以除烦，枳实、厚朴利气以消满。

曾在湖北潜江治一董姓妇女，心烦懊_忪，昼轻夜重。夜间常欲跑到野外空旷之处，方觉舒适，并有脘腹胀如物阻塞之感。脉弦数，舌尖红，根部苔黄，小便色黄，大便尚可，辨为胸膈火郁，胃脘不和之证，遂用本方施治而取效。

伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，栀子干姜汤主之。
(84)

栀子干姜汤方：

栀子十四枚，擘 干姜二两

上二味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服。温进一服，得吐者，止后服。

【解析】本条论述虚烦兼中寒下利的证治。

“丸药”指汉时流行的一种泻下成药，常见制剂有两种，一是以巴豆为主要成分的热性泻下剂；一是以甘遂为主要成分的寒性泻下剂，作用均较峻猛。伤寒病在表，误用丸药大下，为治不得法，徒伤中气，以致太阳之邪内陷胸中，而见身热不去，微烦。言“微烦”，似较上述心烦不得眠，心中懊恼，反复颠倒之烦略轻一点而已。大下之后，脾阳受伤，运化失职，故当有续自下利之证。治以栀子干姜汤，既清热除烦，又温中止利，此即寒热并用不悖之法。

凡用栀子汤，病人旧微溏者，不可与服之。(85)

【解析】本条提出了栀子汤的使用禁忌。

“凡用”二字，概括了第79~84条的栀子诸汤证。“旧微溏”，乃指宿疾，即素日脾胃阳虚或脾肾阳虚之人，而大便经常溏泄。此时即使有火郁胸膈之虚烦证，也应慎用栀子诸汤。因为栀子苦寒，走而不守，易伤脾肾阳气而使溏泄更甚。若非用栀子不可时，亦当减少用量，或仿上条栀子干姜汤寒热并用之法，酌加温补脾肾的药物。只要对邪正、寒热、上下能以统筹兼顾，就可以避免医疗失误。

综上所述，栀子诸汤证除共有“虚烦”主证外，其兼证有少气、呕吐、胸中窒、心中结痛、腹满卧起不安、中寒下利等证，诸证虽异，但其病位都不离胸脘，也即上至心胸，下达脘腹。正因于此，在方证归类时，有的注家将栀子豉汤证划在“太阳病篇”，亦有的注家主张划到“阳明病篇”。持前论者，注重外有“身热不去”一证，强调胸与体表邻近的密切关系，将栀子豉汤证作为表邪内陷，热郁胸膈的太阳变证。持后论者，注重“腹满”一证，认为热已入胃而未成燥结，仅次于小承气汤证。柯韵伯更有其独特的见解，他认为“阳明以心胸为表”，栀子汤证是“病在胸腹而未入胃腑”，其热有自内外达之势，故不当下；栀子豉汤既清

阳明之里热，又散阳明之外邪，善治阳明热未成实的半表半里证，故被列为“阳明起手三法”之一。

太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身^𦈭动，振振欲擗地者，真武汤主之。（86）

【解析】本条论述太阳病过汗伤阳而致阳虚水泛的证治。

太阳病本当发汗，但不可过汗。太阳与少阴为表里，少阴为太阳的底面。若过发太阳之汗，势必要耗伤少阴阳气，以致出现阳虚的诸种变证。所谓“汗出不解”，非指太阳病不解，而是疾病未愈的互词。“仍发热”，亦非表证之热，而是汗多伤阳，阴寒内盛，迫使虚阳外越的表现。夫阴虚阳盛者每多动风；而阳衰阴盛者每多动水，这是疾病发展的一个常见规律。肾主水，为水脏，肾阳虚衰，则制水无权，往往导致寒水之气得以上乘。寒水之气凌心犯胃则见心悸或心下悸；上冒清阳则见头目眩晕，据临床观察，亦有发生头痛者。“身^𦈭动”，即身体筋肉跳动；“振振”，指肢体震颤摇动；“欲擗地”，擗，作仆解，即站立不稳，欲仆倒于地之象。皆因阳气虚衰，周身筋脉失其温养，再加之水湿之邪浸渍所致。由于本证之水邪为患仍因阳虚不能制水而致，且这种水邪或上或下，或表或里，甚或充斥周身，其势浩浩荡荡莫之能御，所以古人称之为阳虚水泛证。治用真武汤扶阳以镇水。

真武汤，亦名玄武汤。玄武为坐镇北方的水神，因能制水而镇摄水邪，故以之命名。本方是温阳利水的代表方，具有扶阳祛寒镇水之功，用于阳虚水泛证最为适宜（方解见“少阴篇”）。

真武汤证与五苓散证均为水证，应作比较鉴别：真武汤证是少阴水脏阳衰，司水无权而水邪泛滥；五苓散证是太阳水腑气化失常而水液停蓄。一在少阴，一在太阳，一脏一腑，证治各别。

五苓散在栀子豉汤证前，真武汤又列栀子豉汤证后，反映了仲景论水证、火证以资对比，而加强辨证之义。

咽喉干燥者，不可发汗。（87）

【解析】本条论述阴虚咽燥者不可发汗。

从本条以下连续七条都是不可发汗的举例，当然也都是麻黄汤的禁忌证。根据以下不可发汗诸条都载有误汗后果来看，本条的“不可发汗”下可能有缺文。咽通于胃，喉通于肺，咽喉为肺胃之门户，为“诸阴之所聚”，尤其是手太阴和足少阴之经脉，均贯于喉。咽喉主发声音、司呼吸、进饮食，是人体与天气、地气交通的要道。它必依赖于肺、肾

的阴液滋养润泽。今咽喉干燥，说明人体阴液不足，特别是肺肾之阴已亏，此时即使病人患有太阳表证，亦不可发汗，发汗必更伤太阴、少阴之阴。且阴虚者多生内热，辛温发汗，不仅耗阴而且更助阳热，从而可能导致不良后果。原文虽未指出其证候，然据理推测，可能会发生咽喉肿痛，甚则伤阴出血等变证。因此，临床治疗外感疾病时，要注意询问病人咽喉是否干燥，特别是温病初起常可见到咽喉干燥，此时切忌用辛温发汗之剂，而宜用辛凉、甘寒之药。

淋家不可发汗，发汗必便血。（88）

【解析】本条论述阴虚有热的淋家不可发汗。

淋，是指小便淋沥不尽，尿意频而尿量少，尿时作痛的一种病证。“淋家”，指久患淋病之人。一般淋病多因膀胱有热而致。由于膀胱与肾相表里，膀胱腑热，日久不解，必伤少阴之阴。这种膀胱热盛，少阴阴亏的病人，即使有太阳表证亦不可发汗，因为以辛温发太阳之汗，不仅会助膀胱之热，而且要更伤少阴之阴，以致发生阴虚火旺，侵犯阴络而尿血的坏证。

疮家虽身疼痛，不可发汗，发汗则痉。（89）

【解析】本条论述营血不足的疮家不可发汗。

“疮家”，指久患疮疡流脓淌血而不愈的患者。“身疼痛”的原因有两种可能：一是由于久患疮疡，营血受伤，筋脉失养所致；二是疮家又外感寒邪，以致卫闭营滞所引起。从“虽身疼痛，不可发汗”之句看，应以有表邪存在为是。但疮家虽患伤寒，亦不可发汗，因为汗血同源，发汗必更伤营血，以致血虚不能润养筋脉而发生痉病。“痉”，赵本作“痊”，证见筋脉拘急，口噤不开，角弓反张等证。疮家有的即使不经发汗也会出现痉病，如再误发其汗，则更促进痉证的发生。《医宗金鉴·杂病心法要诀》说：“痊病项强背反张，有汗为柔无汗刚，生产血多过汗后，溃疮犬咬破风伤。”由此可见，痉病的发病原因是多方面的，而过汗伤津耗液，只是形成痉病的一个原因。

以上87条到89条，讲的都是营血虚禁汗的例证，其中咽喉干燥者是病在上焦；淋家是病在下焦；疮家则是病在体表，此三条并列，有相互对比启迪之义。

衄家不可发汗，汗出必额上陷，脉急紧，直视不能眴，不得眠。（90）

【解析】本条论述阴血不足的衄家不可发汗。

对本条的句读和注解，历来争论较大。如有的把“汗出必额上陷脉

急紧”作一句，有的断句为“汗出必额上陷，脉急紧。”“额上陷”，有的认为前额都是硬骨，不可能陷下，当是指额的两旁。“脉急紧”，有的注释则认为乃指寸口之脉急紧，非指额上血脉。结合临床实际考虑，“额上陷脉急紧”，可当作一句，“额上陷”指头额上肌肉塌陷，“脉急紧”指头额上的血脉拘急。“衄家”指经常鼻衄之人。鼻衄多因阳经有热而动血所致，衄久又必致阴血亏虚，故衄家虽有表邪也不可发汗。若不顾其虚，强发其汗，势必更加损伤阴血而助阳热。阴液耗脱，则可见“额上陷”。额，位于颜面上方正中，阳明主额，其经脉分布于此，人体气血津液之盛衰，在此处反映最为明显。临床所见亡阴失水患者，其额部肌肉多呈干瘪塌陷即是明证。额上“脉急紧”，一因发汗后无阴血充养滋润，二因辛温发汗助其阳热，邪热燔灼，致使血脉拘急而紧。“诸脉者皆属于目”，由于血脉拘急，又加之阴血不足，目精失养，故“直视不能眴”。“眴”，音义同“瞬”，意即眼球转动，“不能眴”，即指两目直视、呆滞而不能活动的情态。“不得眠”，是因阴血虚不能敛阳，阳不能入于阴所致，即所谓“阴虚故目不瞑”。

亡血家，不可发汗，发汗则寒慄而振。（91）

【解析】本条论述各种失血者亦不可发汗。

“亡”，在此作丢失解，非灭亡之义。“亡血”包括各种失血证，如吐血、便血、月经过多、产后出血等等。“亡血家”，指平素因于各种原因引起的失血患者。气帅血行，血为气府，气血相互依存，亡血家不仅伤血，而且也必然耗气。正由于此，故亡血家虽患伤寒表证也不可发汗。若强发其汗，不但更伤阴血，而且也更损阳气。《难经》说：气主煦之，血主濡之。气血两虚，温煦濡润失职，故“寒慄而振”，即从心里感到寒冷，以致周身颤抖动摇。这是阴虚及阳，阴阳皆虚，气血不足的重证。

汗家重发汗，必恍惚心乱，小便已，阴疼，与禹余粮丸，阙。（92）

【解析】本条论述平素多汗者不可发汗。

“汗家”，指经常出汗不断的人。由于汗乃阳气蒸化津液而成，故汗家多有津气阴阳不足之证。又心主血，而主神志，血足则神旺，心神方能任物。且血汗同源，汗为心之液，故重发“汗家”之汗，必更伤心之气血。心失所养，则神虚不能任物，以致神识恍惚，心乱不能自主，“恍惚”为不明之貌，亦即指神识若明若暗，不甚清楚。“小便已，阴疼”，指小便后尿道疼痛。此因心与小肠相表里，心之阴血虚，必然影响小肠阴分不足，阴虚而生内热，故小便已阴疼。治用禹余粮丸。

禹余粮丸，原方失传。《甦生的镜》补一方可供参考。其方组成如下：禹余粮、龙骨、牡蛎、铅丹、茯苓、人参，共为末，粳米为丸，朱砂为衣，如绿豆大，每服3~6克。

病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蚘。（93）

【解析】本条论述脏寒者不可发汗。

“病人有寒”，指脏腑有寒。联系病证所见，主要是指脾胃虚寒，可能伴有腹痛下利等证。本为脏寒，复发其汗，则更伤中阳，阳虚阴盛，必致“胃中冷”。胃寒气逆，故作呕吐。如果病人素有蛔虫寄生，因脏寒而动，可能会导致吐蛔，无蛔者仅呕吐而已。临床所见，吐蛔不止者，预后多不良；吐蛔不食者，有胃气衰败之险；吐死蛔者病多危重。医者不可不察。“蚘”为“蛔”的异体字，关于蛔证，在“厥阴病篇”还有评论，在此不多赘述。

以上诸条，均论不可发汗，一般多认为是麻黄汤的禁例。为了便于记忆，可简称为禁汗七证，即咽、淋、疮、衄、血、汗、寒。它们的共性都是正虚，即伤寒夹虚证。仲景告诫医者，不可发虚人之汗，并指出了误汗的后果，以示人切记“保胃气、存津液”之宗旨，做到防患于未然，具有重要的临床意义。联系第50条“尺中脉微”不可发汗，第51条“尺中迟者”不可发汗，乃言不可发汗之脉。此处七条，言不可发汗之证。前后合参，则禁汗的脉证俱备。汗法有宜、有禁，何时宜汗，何时禁汗，《伤寒论》论述精详，条理分明，使人有法可循，有理可据。

然而，虚人外感不可发汗，应以何法治之？前贤有或先扶其阳者；或先养其阴者；或先建其中者，总以扶正为要，小建中汤一法即是范例。后世医家则更有创新，如《千金方》的滋阴发汗法；张景岳的助阳发汗法；李东垣的益气发汗法等等，都做到了正邪兼顾，体现了扶正与祛邪的辩证统一，也可以说是对《伤寒论》汗法的继承和发扬。

本发汗而复下之，此为逆也；若先发汗，治不为逆。本先下之，而反汗之为逆；若先下之，治不为逆。（94）

【解析】本条论述表里先后的治法。

这一条可作两种解释，首先从字面上解释，即病在表当用汗法，若没发汗而反用下法，这是治疗之逆。逆，指不顺于治疗之理，如先发汗解表，则是治疗不为逆。病在里应当泻下，而反用了汗法，这也是治疗之逆，若先泻下就不为治逆。若进一步引申其义，从条文中汗、下治法的“先”字体会，有先必有后，说明病有表里两个方面的问题，先治什么，后治什么，应当正确选择。“本发汗”，言病有表里证，本当发汗，

若汗后表不解者，可以再汗；若“复下之”，即表不解而改用下法，这是治疗之误。正如第45条所说：“太阳病，外证未解者，不可下也，下之为逆。”“本先下之”，言病有表里证，而以里证突出为急为重，此时当先用下法治里，后用汗法治表，若仍按先表后里的常规治法，也是不合适的；而如果先行泻下以治里急，则“治不为逆”。然纵观《伤寒论》全书治法，表里同病先汗后下，或汗下并用表里双解者皆有其例，而唯独表证未解先用下法，则令人难以理解，临床实例亦难找寻。如蓄血、大结胸、阳明腑实等证，病势颇急，但仲景仍告诫医者：“其外不解者，尚未可攻，当先解其外”，或“其脉浮大者不可下”，或“外未解者……未可与承气汤。”因此，学习本条又不可拘泥于泻下，似应与下条表里缓急治法联系理解为好。对本条中的“下之”，不能简单地理解为攻下的治法，而应作为“治里”来讲，也就是说，有表里证时，里证急者就先治里。而治里之法很多，不必局限于“下之”。下条就具体讨论这个问题。

伤寒医下之，续得下利，清谷不止，身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里宜四逆汤；救表宜桂枝汤。

（95）

【解析】本条论述表里缓急的治法，即表里证治的变法。

伤寒误用泻下之法，损伤少阴阳气，阳虚不能腐熟水谷，则见下利清谷不止。“清”，同圉，厕所的意思。“清谷”，即泻下不消化的食物，“不止”是指腹泻程度较重。下利清谷属虚寒下利，亦称“少阴下利”。误下之后表邪不解，仍见身疼痛，从而形成了太阳表邪不解又见少阴阳虚的表里证。在生理上，太阳、少阴互为表里，太阳为标，少阴为本。在病理上，正与邪两方面，邪为标，正为本。下利清谷不止，是少阴阳虚，即正虚，故为本证。身疼痛是太阳表邪不解，即邪实，故为标证。表里同病，治疗应分清主次，辨明标本缓急，应先治其主证、本证、急证。下利清谷不止，是少阴阳气虚衰，根本动摇，其证急重，故当“急救其里”。如仍按一般的先表后里之法，而强发虚人之汗，不仅邪不能解，反更伤正气，甚至造成亡阳虚脱之变。所以言“救”，一是有急救之意，一是指病不能阴阳自和而自愈，必须通过药物，即以四逆汤急温其阳，实有扶正以祛邪之意。服四逆汤后，其结果或可能是阳回正复，利止表解，诸证悉愈；或可能是里证虽愈，但表证不除，身疼痛尚存，此时理应再予治表。仲景为了提示人们注意，对少阴阳虚初复之后的太阳表证不可等闲视之，若不及时解表祛邪，则表邪很有可能传经入里，故在里虚初复之后，又强调“急当救表”，以绝表邪传里之后患。但考虑到里阳初复，故虽见身疼痛、恶寒无汗之表实证，亦不可用麻黄汤峻汗，只宜桂枝汤调和营卫，以图缓汗而解除表邪。

病发热，头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤。（96）

【解析】本条论述表实里虚，表里同病当先救里的治法。

发热头痛，是太阳表证。表证当见浮脉。今反见沉脉，沉以候里，沉主水为少阴之脉。脉证合参，本证属太阳与少阴两感为病，可用麻黄附子细辛汤或麻黄附子甘草汤温经散寒，即内温少阴之阳，外散太阳之寒。但是服汤后“若不差”，即表里证不解，身体疼痛仍在，甚至还见有少阴阳虚的下利清谷等证，病非但不愈，反趋严重，说明少阴阳气十分的虚衰，此时则以里证为急，故当以四逆汤温阳固本为宜，而不能再辛温解表之品。此处虽未言再治表，实则解表寓于回阳救逆之中，正如张璐玉所说：“与四逆汤回阳散寒，不解表而表解矣。”

太阳病，先下之而不愈，因复发汗，以此表里俱虚，其人因致冒，冒家汗出自愈。所以然者，汗出表和故也。得里未和，然后复下之。（97）

【解析】本条论述汗下失序以致眩冒的治法。

太阳病本当发汗，却先用泻下，故而不愈。接着又行发汗，如此汗下颠倒，违背了治疗的常法。先下伤里，复汗伤表，汗下失序，以致营卫气血皆伤，即所谓“表里俱虚，其人因致冒。”冒指头目昏眩，如有物蒙蔽之感。由于在汗下之后，虽邪气亦微，但正气受挫，清阳之气不能升达头目，所以眩冒。其证属正虚邪微，故不能再发汗。可待其正气自行恢复，阴阳调和而汗出自愈。因为汗出表示阳气已复，已能蒸化津液出于表，而外邪亦可随其势而外解，则“汗出表和”而自愈。如果眩晕愈后，又出现了大便秘结、心烦、蒸蒸发热等阳明胃气不和的见证，可再用调胃承气汤泻下以和胃气，此即所谓“得里未和，然后复下之”的意思。

审证求因，推其眩冒之理，则为风邪上胜，属于“无风不作眩”之类，临床常可见到汗出而眩晕作解者。我也曾见梅尼埃综合征患者，在眩晕剧作时，突然汗出，面色苍白，一时痛苦难耐，然随后诸证悉除。其机理可能与本条所论有相似之处。

太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振慄，汗出而解。但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解。若欲下之，宜调胃承气汤主之。（98）

【解析】本条主要论述伤寒热病有从战汗作解的机理。

太阳病在未解之时，突然见“脉阴阳俱停”。对“停”字，各注家有不同

同的解释，有说停者，止也，认为脉有停跳；有说停者，调也，认为脉搏调和，以上两种说法都很牵强。赵本把“停”作“微”，亦有把“停”作“沉”的，我们认为，作微、作沉的说法，比较有道理。因为脉阴阳俱微或阴阳俱沉，正是正邪相争的一种表现，此时阳气欲拒邪而外出，有一积蓄力量的过程和先屈而后伸的程序，所以阳气向内，从而使寸、关、尺三部脉俱见沉、微。邪压正气，正气起而与争，正邪相搏，同时病人还见有振振摇动，从内心感到寒栗发冷的证候，这种现象叫“战、振、栗”，俗称为“寒战”。不过这种寒战是有劲的，与真武汤证阳虚无力的振振欲擗地不同。寒战时间的长短，取决于患者体质的强弱。体质较好，正气旺盛者，一般寒战十几分钟后就开始发热。发热是阳气得伸的表现，随之则正胜邪却，见身出大汗而其病得解，脉亦恢复正常。但也有正不胜邪，不能拒邪外出，见战而不汗者，此时当用药物助正以抗邪，以求汗出病解。还有战汗之时肢体无力振摇的，这表明正气大衰，将有虚脱之险，应积极用药救治。此外，对战汗病人的护理也甚为重要，每当战汗发生之时，患者及家属难免为之惊惶，医者应预先叮嘱“见战勿惧”。同时要注意季节的寒暖，室温和通风的适宜。若战汗之时，有口渴或饥饿感的，可令其稍进饮食，如热汤、热水，夏天亦可饮以清凉饮料之类。张景岳的医案即有战不得汗，经进食炖烂的羊肉而使汗出之例。无论伤寒、温病，凡外感热病都能发生战汗，尤以温疫为多见。据临床观察，战汗发生多有一定诱因，其中不少发生在服药之后。如服小柴胡汤或小陷胸汤，甚至服硝黄泻剂亦可诱发战汗。至于发生战汗的机理，犹如服栀子豉汤作吐一样，均是药物助正，驱邪外出的反映，并非是某方某药专可使人战汗。曾治一产后高热患者，扪其肌肤高热灼手，脉来洪大，舌见黄苔，大渴欲饮，但家人又不让饮。时值炎夏，家人以产后避风为戒，密闭门窗，并使病人身着棉衣。审此情况，即命开窗启户，并嘱产妇畅饮凉水。饮后片刻，寒战大作，脉见沉伏。其家人皆惊惶不已，向余问罪，指为误治。但未料病人战后汗出，竟热退身凉而愈。联系前后病情分析，此患者原是产后邪热伤津，本无汗可以作战，今饮水后增其汗源，益其津液，故有战汗作解之资本。

“但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解”，这是以脉象为依据，以判断疾病或从汗而解，或从下而解。阳脉微即寸脉微，寸以候表，候上而属阳；阴脉微即尺脉微，尺以候里、候下而属阴。邪气闭郁之所，有表里上下之异；正气驱邪外出，又有在阴在阳之别。邪闭郁于阳，则从汗而解；邪闭郁于阴，则从下而解，即通过下利而解。如太阴病“脾家实，腐秽当去”的暴烦下利，即是从下而解的实例。若不能自行下利作解，可酌用调胃承气汤等泻下。

太阳病，发热汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤。（99）

【解析】本条补述太阳中风卫强荣弱的病机。

太阳中风证前已述及，本条又补述其发热汗出乃是由于“荣弱卫强”所致。“卫强”是指风阳并于卫阳，卫分之邪强，正邪相争，而见发热。卫受邪不与荣和，则荣阴失去卫阳的固护，且又被风邪所泄而不能内守，故使汗出。汗出伤荣，故谓“荣弱”。“强”指邪气盛，“弱”指正气虚，“荣弱卫强”即荣卫失调。治以桂枝汤解肌祛风而调和荣卫则愈。

以上冒家自汗，热病的战汗，和本条的发热汗出，都是不借药力而自发的不同汗证，张仲景将此三条并列于太阳病汗法之后，其目的是使人了解汗出表解有各种不同的情况，借以提高辨证分析的能力。

本论太阳病中篇至此，已论述了麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤、大青龙汤、葛根汤等五个治疗太阳病的发汗之法，并已将这些汗法的各种禁例，和表里缓急等治则全盘托出而论述完毕。此时作者笔锋一转，进而论述太阳表邪向少阳半表半里的传变，由此引出了少阳病的主证与主方——小柴胡汤证。这种写法，实有总结太阳表证和指导对邪传少阳半表半里的辨证论治的意义。

伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，与小柴胡汤主之。（100）

小柴胡汤方：

柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 甘草三两，炙 半夏半升，洗 生姜三两，切 大枣十三枚，擘

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，取三升，温服一升，日三服。

后加减法：

若胸中烦而不呕，去半夏、人参，加栝蒌实一枚。若渴者，去半夏，加人参，合前成四两半，栝蒌根四两。若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两。若胁下痞鞭，去大枣，加牡蛎四两。若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两。若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝本有“枝”字三两，温复取微汗愈。若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升，干姜二两。

【解析】本条论述少阳病的证治。

“伤寒五六日，中风”，意即太阳病伤寒或者中风，大约过了五六天。其后出现了往来寒热等证，则反映邪已传入少阳。少阳病的发热，既不同于太阳病的翕翕发热，也有别于阳明病的蒸蒸而热。而是寒热交替出现，一会儿发冷，一会儿发热，热时不寒，寒时不热，故称往来寒热。这一发热的特征是由于少阳所在的部位及其生理特点所决定的。

《素问·阴阳离合论》说：“太阳为开，阳明为阖，少阳为枢。”吴崑解释说：“太阳在表，敷畅阳气，谓之开；阳明在里，受纳阳气，谓之阖；少阳在于表里之间，转输阳气，犹枢轴焉，故谓之枢。”太阳为开，其病为表证；阳明为阖，其病为里证；少阳为枢，其病为半表半里证。另外，少阳胆腑依附于肝，其位也在胁下，与肝表里相连，其气也有疏泄作用，可通达表里内外。外可从太阳之开，内可从阳明之阖，开则为阳，阖则为阴，此即少阳为枢之意。少阳受邪，正邪分争，进退于表里之间，必然影响开阖枢机的不利。当邪胜于正，由外向里、由阳入阴之时，则表现为恶寒；当正胜于邪，能抗邪外出，使邪气由阴出阳时，则表现为发热。由于正邪相争各有进退，从而导致了寒来则热往，热来则寒去，呈阵发性交替发作的往来寒热。这是少阳病一个特别重要的见证，故列于诸证之首。“胸胁苦满”，“满”当读作“懣”。虽然胸与胁并论，但实际以胁满为主。“苦”是苦于“满”的意思。因少阳经脉行于胸胁，少阳受邪，经气不利，故见胸胁苦满。“默默”，形容表情抑郁，静默寡言，是反映肝胆气郁的精神状态。“不欲饮食”则是肝胆疏泄不利，影响了脾胃运化功能，致使胃口不开，食欲不振的表现。由于“默默”与“不欲饮食”都因于肝胆气郁，疏泄不利，二证又常同时并见，故称为“默默不欲饮食”，以示气郁为病的特点。少阳胆木内藏相火，气郁则火郁，郁火扰心则见“心烦”。“喜呕”的“喜”，有多、善之意。“喜呕”，即指频繁的呕逆而言，乃因少阳不和，胆热犯胃，胃失和降所致。

上述皆为少阳病主证，以下分析或见证。少阳病的或见证很多，其原因是少阳介于表里之间，居枢机之地，其手足两经隶属于胆和三焦。少阳受邪，则半表半里之气不和，邪气有表里出入、乍进乍退之机，不仅使肝胆气郁，而且三焦之气也往往为之不利。因此病变所及可达表里内外、以及上中下三焦之气的不和，致使发生“或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞鞭，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳”等证。虽谓或见证，但也是客观存在的病变反映，且在某些情况下，或见证亦可成为主证，因此对或见证也不得轻视。不仅如此，作为理论上的系统学习和临床上的灵活运用，还应理解和牢记。否则，将造成见其证而不能辨认，用其方而不知化裁的问题。

病在少阳半表半里，其治既不能发汗，更不能吐下，只有疏解少阳之郁滞，使枢机得利，三焦得通而达到表解里和的目的，这就叫做“和解之法”，小柴胡汤则是和解法的代表方剂。

本方由七味药物组成，除柴胡外，其余六味均可以等量用之，一般用三钱，即10克左右。因柴胡为方中主药，一定要重用。之所以名以小柴胡汤，是与大柴胡汤相对而言。柴胡古时用八两，现在约八钱，合24克左右。乍看去似乎药量过大，实际原方煎剂是分三次服用，每次药量不到10克。现在煎药只分两次服用，故可酌情减量，但必须要用足药量。特别是治疗典型的少阳证，柴胡非重用不可。《神农本草经》载：“柴胡性味苦平，主治肠胃中结气，饮食积聚，寒热邪气，推陈致新。”《神农本草经》所载能推陈致新的药物仅有二味，一是大黄，从血分而言；一是柴胡，从气分而言，足以说明柴胡用途之广。然而现时有一些人临床使用本方疗效不理想，就认为方已过时，其实疗效不好的原因，往往是因其药量使用不当。如有的人不遵原方配伍比例，误将柴胡与他药等量；也有的人唯恐“柴胡劫肝阴”，而不敢用足其量；甚至有的人视柴胡为可畏，竟不敢动用毫厘。若依此遣方用药，则怎能取效？方药剂量是历经多少年代与多少医家的临床验证而确定的，今天我们若不经反复实践就轻易否定，未免有些轻率。

小柴胡汤中既有祛邪清热之药，又有扶正补虚之品，可谓是集寒热补泻于一方。本方药物可分三组。一是柴胡配黄芩，为方中主药。柴胡能疏解少阳经中邪热，黄芩可清泄少阳胆腑邪热，柴芩合用，经腑皆治。同时柴胡还能疏利肝胆，条达气机，柴芩相伍，使气郁得达，火郁得发。本论之方用柴胡者共有七个，其中小柴胡汤、大柴胡汤、柴胡桂枝汤、柴胡桂枝干姜汤、柴胡加芒硝汤、柴胡加龙骨牡蛎汤等六方，都以柴、芩为主药，故亦可称之为柴胡剂群。而四逆散一方，仅有柴胡而无黄芩，则不属柴胡剂群之内。二是半夏配生姜，又名小半夏汤，因其

能和胃降逆，散饮祛痰，故称为止呕圣药。少阳病“喜呕”，呕是少阳的主证之一，故半夏、生姜在所必用。同时夏、姜味辛能散，对疏通少阳郁滞也有裨益。三是人参、甘草、大枣相配，扶中益气。对于一般外感病来说，用人参等甘温益气之品者较少，以防闭门留寇之弊。本方选用此药，作用有二：一是助正以祛邪，因少阳之气为小阳、弱阳，抗邪之力不强，故需扶正以祛邪；二是补脾以防邪气传变，因太阴位居少阳之后，少阳之邪若再内传，太阴则首当其冲，默默不欲饮食即是先兆，故“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”，用此三药正是实脾而杜绝少阳之邪内传之路。再从药物性味看，柴苓味苦、夏姜味辛、参草枣味甘，合成辛开、苦降、甘调之法，太阳病下篇治痞的泻心汤也属此法，亦称和解之法。可见小柴胡汤配伍的三个方面，三组药物，既各奏其功，又相辅相成，构成了一个有机联系的治疗整体。

原方要求去滓重煎，使之浓缩，从六升再浓缩成三升，分三次服用。这是古人的经验，凡用和解剂，都如此煎药。前人认为，和解剂中，诸药性味有或苦、或辛、或甘之不同；其作用又有或清、或补之区别；其效应又有或取其气，或取其味的差异。若按一般煎法，则性味不匀和，效应不一致，而去滓重煎则可使诸药性味匀和、作用协调。但现今此种煎药方法已多不沿用，也同样有效。

原方后所附七种基本加减法应掌握。实际上本方加减化裁变化甚多，运用极广，但其范围总不外表里寒热虚实六个方面。换言之，它既可和解表里，又可调和阴阳，且能调节上下升降，故不仅治疗外感热病，还能治疗内伤杂病。犹如桂枝汤在外可调和营卫，在内能调和脾胃一样，两方运用之广确有媲美之处。本方治疗肝胆疾患常是得心应手，对于慢性低热、急性高热，以及所谓“无名热”兼有少阳证者，其退热作用也十分显著。如曾治某瓷器厂一青年女工，低热久久不愈，伴有胸胁苦满，月经不调，行经腹痛，乳胀，呃逆等证，六脉皆弦。病本为肝胆气郁，化热伤阴之候，而医者不知低热由何而生，尽用鳖甲、生地、地骨皮等一派滋阴清热药物。虽有时低热暂退，但总是反复发作，始终不愈。后投小柴胡汤加减，仅数剂而病愈。又如某患儿因患急性肝炎、急性肝坏死，住某传染病院，高热40.5℃持续不退，用他药无效，病情十分危重。急予小柴胡汤加石膏，连用两剂，高热渐退而化险为夷。

其实，小柴胡汤的退热功效，早已被前人所重视，如北宋时沈括的《苏沈良方》即提出小柴胡汤用之“最的当”的五种证候中，就有身热、往来寒热、潮热、伤寒瘥后更发热等四种发热证。而今人们已对此更加重视，有的医家把本方从和解剂移至清热剂中，即是很好的说明。

血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下，正邪分

争，往来寒热，休作有时，默默不欲饮食。藏府相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也。小柴胡汤主之。（101）

【解析】本条论述少阳病，特别是小柴胡汤证的病因和病机。

上条讲少阳续发于伤寒或中风，本条是病邪直接侵犯少阳，从而补充了少阳发病的原因。同时又阐述了少阳病的病理机制，因此，这两条应联系互参。为何外邪不经太阳而可直接侵犯少阳呢？原因是“血弱气尽，腠理开”，人体气血虚衰，腠理不固，外邪乘虚直入，与正气相搏，结于胁下。胁下是少阳所属的部位。正邪分争，各有胜负进退，故见往来寒热，休作有时。休作与往来的意义相仿，说明寒热不同时出现，而是寒休热作，或热休寒作。既然邪犯少阳，必然殃及其他脏腑，因为人之“脏腑相连”。少阳胆为腑，胆附于肝，少阳与厥阴经脉互相络属。肝胆表里相连，所以“其痛必下”。所谓“下”，非指位置的高下，而是指其所影响的器官以及病变发展的趋势，即由表及里，胆病及肝，以致肝胆之气皆为不利；或旁及脾胃，致胃气不和“故使呕也”，脾气不和则“不欲饮食”。辨证至此，其理已明，用小柴胡汤主治无疑。

服柴胡汤已，渴者，属阳明也，以法治之。（102）

【解析】本条接上条说明少阳之邪不解可转属阳明。

少阳病服小柴胡汤以后，如果少阳之邪得解，胆气疏利，三焦通畅，津液得复，其病则愈，也不会再作渴证。如果服汤后反见渴者，是少阳之邪转属阳明，而不是少阳病的兼证之渴。因其邪传阳明，少阳证已罢，这种渴证是服汤后出现的新问题，也即是阳明里热，灼伤津液的病理反映。不过此时邪热初传阳明，尚未热结成实，仅是阳明热证而已。治疗当然不能再用小柴胡汤以和解，而应以清法治阳明之热。

本条文虽短，但说明了两个问题：一是说明疾病是运动变化的，传经必有其特定的证候反映，少阳邪传阳明，必先见口渴一证，临床当须注意；二是说明六经传变并不受其正常排列顺序所约束。《伤寒论》三阳经是按太阳、阳明、少阳的顺序排列的，也有人提出少阳属半表半里，应排在阳明之前。其实原著虽如此排列，而论其病变则不拘泥于此。如太阳可传少阳，少阳可传阳明等等，不一而足。临床应据证而辨，以客观证候判断六经病证的传变趋势与转归。

得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者，与柴胡汤。后必下重，本渴，而饮水呕者，柴胡汤不中与也。食谷者哕。（103）

【解析】本条论述小柴胡汤的使用禁忌。

得病已六七日，证见“脉迟浮弱，恶风寒，手足温”。脉浮而弱，恶风寒，类似太阳中风。脉兼迟象，似为阳虚，若再见手足冷便可断为夹虚外感证。但反见手足温，说明并非阳虚，仅太阳表证而已。此时可能稍兼有不大便的里气不和证，但不是里实证。而医者见有不大便，竟不察表里虚实，屡用泻下，以致发生下列变证。误下必伤脾胃，使脾不健运，胃失和降，故不能食。脾虚失运，水湿停滞，加之误下后表邪化热入里，形成湿热郁滞，故胁下满痛。三焦之气不利，则小便难。因为湿无去路，郁蒸发黄，以致面目周身皆黄，当属湿热发黄证。湿邪上犯，闭阻太阳经脉，故颈项强。此类湿热证，当以渗利之法治之，使湿热通过小便排除。但医者不明此理，一错再错，误认为颈项强是太阳证，胁下满是少阳证，错当太少合病或并病而用小柴胡汤，从而造成了误治。小柴胡汤内有参、草、枣等甘温之品，服之必增湿热，而柴、芩之苦寒，也对里气不利，以致发生大便如痢一样下重不畅的变证。

“本渴，而饮水呕者”，此属饮家。因胃有停饮，津液不化，故渴；因渴而饮，水停更多，水邪上逆，故而作呕。这种饮家作呕与少阳病的心烦喜呕绝然不同，治当用半夏、茯苓、生姜之类涤饮则愈，切不可用小柴胡汤治疗。若误用之，必因其苦寒伤败胃气，使饮气更逆，而见“食谷则哕”之变。“哕”，即呃逆，类似膈痉挛之类。有的注家认为此句衔接突然，疑有缺文，学者可进一步考证研究。

伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。（104）

【解析】本条论述三阳合病，治从少阳之法。

伤寒四五日，出现“身热恶风，颈项强”，此属太阳表证；“胁下满”为少阳半表半里证；“手足温而渴”，是阳明里热证。三阳病证同时俱见，将如何治疗？夫少阳禁汗，故不能用发汗法，若用清热之法，则又易使太阳表邪郁遏。古人说的“三阳合病独取阳明”的治法，仅适用于阳明热盛之候，对本证也非所宜。只有用小柴胡汤和解少阳，使枢机利，表里和，则三阳之病俱解，此即所谓“三阳合病治从少阳”之法。但因有口渴一证，似宜于小柴胡汤方中去半夏加栝蒌根以生津止渴。

本条与第103条比较，都有颈项强、胁下满、手足温等证，但两者病机不同。第103条的见证为湿热所致，本条的见证则为“合病”，故第103条属小柴胡汤禁忌证，而本条则是其适应证。两条对比，有加强辨证分析的意义。

伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛者，先与小建中汤；不差者，与小柴胡汤主之。（105）

小建中汤方：

桂枝三两，去皮 甘草三两，炙 大枣十二枚，擘 芍药六两 生姜三两，切 胶饴一升

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火，消解，温服一升，日三服。呕家不可用建中汤，以甜故也。

【解析】本条论述土虚木乘，少阳夹虚的证治。

肝胆之病最易影响脾胃，即所谓“木乘土”之理。如果病人素有脾虚，又患少阳证，则因肝胆气横更伤脾气，而发生腹中急痛。因此治疗上就有先扶正后祛邪、先治脾后治肝胆的方法，本条讲的就是这一精神的体现。

“阳脉涩”，指脉浮取迟涩，为气血不足；“阴脉弦”，指脉沉取见弦，主病在少阳之经，又主痛证。“腹中急痛”，既有自觉症状，也有他觉症状，即腹痛时自觉有紧缩拘急之感，而腹诊时又可触摸到腹肌痉挛紧张而成条索之状。此脉此证，是由于脾虚气血不足，又为少阳之邪相乘所致，即所谓“土虚木乘”。治疗应先扶正后祛邪。先用小建中汤健脾补虚，缓急止痛。服汤后如果脾虚得复，肝胆气平，则诸证皆愈。如果“不差”，即病不愈，而仍见腹中急痛不止，说明肝胆之邪太盛，此时单纯补脾建中犹不能解决问题，还必须再用小柴胡汤（当去黄芩加芍药）和解少阳，疏利肝胆，兼以伐木，方能求愈。

临床有兼腹中急痛者，也有兼胁下急痛者，均可遵循本条之法治疗。如曾治一肝炎患者，胁下急痛，食少乏力，经服多剂柴胡汤不愈。诊其脉弦而缓，断为土衰木乘之候，即用此法，予小建中汤。药后其痛竟止。又如临床上虚劳腹痛脉见弦者，其中也有土衰木乘因素在内，其治亦当先健脾补虚，后疏利肝胆，道理同上。

小建中汤即桂枝汤倍量芍药加饴糖而成。桂枝汤既可调和营卫气血，又能调和脾胃阴阳，在此基础上加饴糖甘温补中以缓急，倍用芍药酸甘益阴而于土中平木，即在补脾之中而兼平肝胆之横，又有缓解筋脉拘挛的功用。诸药合用，能使脾胃健运，气血得充，阴阳平调，营卫协和，则其病自愈。所谓“建中”，即建立中气之意。《金匱要略》用本方治疗因脾胃有病而致气血不足、阴阳失调的虚劳证候，也是通过建立中气而达到调补气血阴阳的治疗目的。

从上述可以看出，建中一法，不仅补脾，而且能治肝胆，因脾虚气血亏少，肝胆失之柔养，则其气必然横逆而急；肝胆之气愈盛，脾胃愈

伤，从而形成土衰不能培木，木急反乘中土的病证。《内经》云：“肝苦急，急食甘以缓之”，小建中汤系甘温补剂，能健脾而生血，肝胆得血濡则气柔而条达，培土即可以制木的意义就在于此。因此，有的患者服小建中汤后，往往肝脾之病皆愈，倘若不愈，再服小柴胡汤去黄芩加芍药也就好了。本条的少阳夹虚先用建中后用柴胡之法，体现了“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”的治则，不仅见于《金匱要略》，而且也见于《伤寒论》。通过本条还可说明另一个问题，即如前所述，小青龙汤对肾虚之人不可用，虽方中有芍药、五味子等保益肝肾之品，但全方毕竟燥烈辛散，用之不当，则有拔肾根、伤元气之弊；本条又讲到小柴胡汤对脾虚之人不可用，虽方中有人参、甘草、大枣等甘温益气之品，但全方毕竟为苦寒之剂，用之不当，亦可更伤脾气，故不可有恃无恐，本条一证而设二方，以别虚实之治，寓意深刻，耐人寻味。

伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。（106）

【解析】本条论述使用小柴胡汤要抓住少阳的主证。

少阳病症状很多，临床上不可能在一个患者身上同时全部见到，因而也无需诸证俱备，才可用小柴胡汤或其他柴胡剂。“但见一证便是，不必悉具”，讲的就是这个意思。“一证”当活看，不要认为就是一个证，更不能认为是任意一个症状。而应该理解为一两个能确实无误地反映出少阳病病变特点的主证，如见到往来寒热或胸胁苦满等，便可使用小柴胡汤。因为往来寒热、胸胁苦满是少阳病具有特征性的证候。往来寒热反映了邪在半表半里，正邪斗争有进退出入的病变特点；胸胁为少阳之专位，苦满反映了少阳气郁，疏泄不利的病变特点，除此之外，或者见到口苦、喜呕；或者见到呕而发热等一两个主证，也可诊断为少阳病。

本条言简意明，旨在告诉读者临床辨证时要善于抓主证。不仅少阳病如此，其他各经之病亦当仿效而行。

凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。（107）

【解析】本条论述柴胡证误下后的证治及机转。

少阳病属半表半里证，本不应泻下，但在临床上又容易犯误下的错误。因为少阳受邪，往往影响三焦气化不利、津液不畅，致使津气不能下达而有不大便的见证。此时若用小柴胡汤外疏内达，使上焦得通，津液得下，胃气因和，在表者可濈然汗出而解；在里者则使大便得下而解。若不遵此法，但见不大便即贸然使用下法，则为治疗之逆，其结果可能出现三种情况：一是造成坏病，甚至转成下利不止、水浆不入等重

证；二是邪传阳明，而成阳明有关的诸证；三是其人正气尚旺，尚没有因误下而发生特殊变化，而柴胡证仍在的，则仍可用小柴胡汤治疗。然由于误下之后，证虽未变，但正气毕竟受挫，值此之时借药力之助，正气奋起向外抗邪，而见“蒸蒸”振战，然后发热汗出而解。这就是正邪交争，战汗作解的一种表现。但需要说明的是，上述病情在临床上并不一定皆能发生战汗，同时也有虽未经误下而仅是因为病程稍长，药后却出现战汗作解的。因此不可拘泥于文字。

伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。（108）

【解析】本条论述伤寒夹虚的证治。

伤寒二三日，病程虽不长，亦未经误治，却见心中悸烦之证，其原因往往是里气虚馁，心脾气血不足，复被邪扰所致。夫太阳与少阴为表里，少阴不仅包括足少阴肾，也包括手少阴心在内。如果说太阳主表而为藩篱，犹如边防之设，那么少阴之心就处于宫城之内。若心宫气血亏虚，则气虚易生悸，血虚易生烦。通常情况下悸、烦尚不明显，一旦感邪之后，正气不支，在表之邪即有内陷之危，此时悸与烦就十分地突出。此证往往较叉手冒心，心悸欲得按的桂枝甘草汤证更重一些，如进一步发展，就可能出现“脉结代”的炙甘草汤证。

本证系虚人伤寒，故不可发虚人之汗。治当先扶其正以强其本。小建中汤内能补益心脾气血之虚，外可调和营卫以增强抗邪之力，一举而两得，也即“安内以攘外”之法。本条与105条都用小建中汤，一治腹中急痛，一治心中悸而烦，虽见证不同，但皆论建中之法。

太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之，则愈。（109）

大柴胡汤方：

柴胡半斤 黄芩三两 芍药三两 半夏半升，洗 生姜五两，切 枳实四枚，炙 大枣十二枚，擘 大黄二两

上八味，以水一斗二升，煮取六升。去滓，再煎，温服一升，日三服。一方用大黄二两。若不加大黄，恐不为大柴胡汤也。

【解析】本条论述少阳兼阳明里实的证治。

本证初起是邪在太阳之表，由于时间的推移或治疗之误，而致邪气

离开太阳传入少阳，即为“过经”。少阳病治当和解，但医生三番两次地用了泻下之法，所幸病人素质尚好，证未因误治而变化，柴胡证依然存在，故仍应先与小柴胡汤治疗。服汤后可能有两种情况：一是药尽其用，正胜邪却，病证向愈，出现如第107条所述之战汗作解；二是药后病证未减反而加重，即由原来的“喜呕”、“胸胁苦满”、“心烦”等证一变而为“呕不止”、“心下急”、“郁郁微烦”等证。“呕不止”，乃因邪热不解，内并阳明，热壅于胃，以致胃气频频上逆所致；“心下急”，即胃脘部或胀满之极、或疼痛之极、或拘急紧张之极而不可耐之谓，为阳明胃热结聚之兆；“郁郁”与“默默”的病机相同，皆为少阳气机郁遏之象，但证情以“郁郁”为重。“微烦”并非轻微之烦，而是指气郁热遏于内，使心烦外见反微。据情可知，其人不大便、口苦、苔黄、脉弦等证也在所必见。

综上所述，病已属少阳兼阳明里实，故用小柴胡汤已无能为力，因其只能和解少阳而不能攻下阳明，唯用大柴胡汤才能双解少阳阳明两经之邪。然少阳病本属半表半里证，有汗吐下三禁，而本条又何谓少阳可下？因禁下是针对单纯的少阳证而言，叫做常法；可下是阳明少阳并病，叫做变法，即和解少阳枢机兼下阳明里实之法。又如太少并病用柴胡桂枝汤，和解与发汗并行，也属少阳治法之变。

据临床所察，由小柴胡汤证进一步演变为大柴胡汤证的并不鲜见。因为少阳肝胆气郁时久，常可化热化燥，使胃气不和而敛结成实。舌苔由白变黄即是标志之一，见舌苔黄即可放手用大柴胡汤。若仍见白苔，说明阳明里热尚未形成，仍属小柴胡汤证。同时，一旦病至大柴胡汤证，无论胀满或疼痛诸证都很急迫难耐，此亦为辨证之眼目，当须牢记。

大柴胡汤是柴胡剂群的重要方剂之一，由小柴胡汤去人参、甘草加大黄、枳实、芍药而成。方用小柴胡汤以和解少阳，因已见里实之证，故去参草之甘补；大黄配枳实，犹如半个承气汤，以泻阳明之实热；芍药配大黄，酸苦涌泄，能于土中伐木，平肝胆之气逆。方中生姜之量，较小柴胡汤中生姜用量为大，一因生姜辛散，能散结去饮以止呕；二因本证邪热聚结在于心下，病位偏上，故重用生姜上行和胃，借以牵制大黄峻猛速下之力，使之“载药上行”而达到调和胃气的目的。如果说桔梗能载诸药上浮而有舟楫作用，此方生姜配大黄则也有这种妙用。然而本方中有无大黄，曾有过争议，或云有，或云无，陈修园对此有个折中的意见，他说临证时根据需要而决定取舍。考原文有“下之，则愈”一语，则知方中自然当有大黄。本方与大承气汤相较，泻下之力虽稍逊一等，但药力也相当可观，临证亦不可轻举妄用。

大柴胡汤既可疏利肝胆之气滞，又可荡涤肠胃之实热，既治气分，又调血分，属肝胆胃肠不和、气血凝结不利的病证，在临床比较多见，因此本方临床应用也较广泛。现时临床用其治疗多种急腹症或一些其他消化道疾病，功效卓著。如急性胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎、溃疡穿孔以及热痢下重等，只要其证候与本方证相符，即可投予本方，或酌加理气活血，清热解毒之品，以提高疗效。曾在某医院会诊一例急性胃穿孔患者，该院已决定手术，但家属唯恐患者年迈多险，而拒绝手术治疗，要求服用中药。证见腹痛不可耐，心烦口苦，恶心呕吐，舌苔黄厚，脉弦而滑。嘱速煎大柴胡汤，服后泻下黑便，腹痛骤减，呕恶亦止。继服原方二剂，诸证好转，后经调理而愈。临床经验证明，凡属气火交郁的实性腹痛，都可用本方治疗，尤其是疼痛偏于腹部两侧的，效果更佳，这是因为少阳经气行于胸腹两侧的缘故。

伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。此本柴胡证，下之而不得利，今反利者，知医以丸药下之，非其治也。潮热者实也，先宜小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。（110）

柴胡加芒硝汤方：

于小柴胡汤方内，加芒硝六两，余依前法。服不解，更服。

【解析】本条论述大柴胡汤证误用丸药泻下后的证治。

伤寒时过十三日而病仍不解，出现“胸胁满而呕”的少阳证，“日晡所发潮热”的阳明证。“日晡”，指午后申时，大约三点至五点的时间；“所”是不定之词，在此指申时左右；“发潮热”，谓其发热像潮水一样按时而至。中医有天人相应，六经合于六气的理论。阳明之气主燥，午后申时，正是自然界燥气旺盛之时，此时人体阳明之气最为强盛，故而抗邪有力，正当其时则发热。这就是日晡所发潮热的缘由。根据上述见证，可断为少阳不和兼阳明里实之证，当用大柴胡汤治疗。若确属大柴胡汤证，本应见大便秘结，而今为何汤药未服却反见下利？查究其因，原来是前医误用丸药泻下所致。丸药多系巴豆制剂，其性辛热燥烈，以丸药泻下，肠道虽通，但燥热不去，少阳证亦不能解除，故曰“非其治也”。因已经泻下，故虽兼有阳明燥热内结，亦不能再用大柴胡汤峻下，可先用小柴胡汤以解少阳，不愈者，再用柴胡加芒硝汤兼治阳明。

柴胡加芒硝汤，即小柴胡汤加芒硝。芒硝咸寒，善能泄热软坚以润

燥。本方攻下之力虽不及大柴胡汤，但去燥热以治潮热的作用，却优于大柴胡汤。据赵本所载，本方只取小柴胡汤原剂量的三分之一，又不减甘草、人参等补药，故对正气较虚，里实而不甚的，比大柴胡汤更为适宜。

伤寒十三日不解，过经，**譫**语者，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当鞅，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也，调胃承气汤主之。（111）

【解析】本条论述太阳过经于阳明而误用丸药下后的变证与治疗。

伤寒十三日，证见**譫**语者，是为太阳过经于阳明。因阳明有热，胃络通于心，热扰心神，故作**譫**语，当用调胃承气汤下之。如果患者小便利且量多，是阳明燥热逼迫津液偏渗而不能还入肠中，故曰“小便利者，大便当鞅”。阳明里实证，本当见大便硬，而今反见“下利”，属虚属实，可凭脉审证。如脉见“调和”的，“调和”并非指无病之脉，而是指阳明病脉未变，仍与里实证相应，则反映此“下利”并非虚证，乃是前医误用丸药泻下所致。“若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也”，则进一步说明了是实证而不是虚证的脉诊依据。“脉当微厥”，诸释纷纭，或说是脉微肢厥，或说是脉微结，根据“厥”字有“极”、“甚”之义，我们认为当以脉来甚微解释为妥。若证属虚寒性的自下利，其脉必然甚微，但今之脉不微，相对来讲反而“调和”，于是阳明里实则信而有征。论其治法，因已经用丸药误下，胃气必有所伤，峻下之剂似不相宜，当用调胃承气汤调和胃气为妥。

以上两条皆有丸药误下的病史，据考证，后汉一些医生习用这类丸药治疗伤寒病，其结果是大便虽通，但内在的燥热不能根除，往往给进一步辨证治疗造成困难。如本来是显而易见的大承气汤证或小承气汤证，由于用他药误下，以致证候错综复杂，使人难于辨识，下不了治疗的决心。如今虽无这种古老的泻下丸药，但类似的误下变证仍不乏其例，譬如常见有不大便者，不论何因，动辄用番泻叶之类的泻药，常常弄巧成拙，甚或造成不良后果。如某年在某地防治流脑时，曾遇诊一流脑后遗症患者，视物模糊、大便秘结，辨证属肝肾阴亏，拟用滋阴增液之法，缓缓图治，冀其阴液恢复，大便自下。其后他医诊时，嫌此法过缓，竟改用硫酸镁泻下以图速效。不料服后大便虽快利于一时，但视力却更趋下降，他证亦见增重。其中的教训应当吸取。

太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃

核承气汤方。（112）

桃核承气汤方：

桃仁五十个，去皮尖 桂枝二两，去皮 大黄四两 芒硝二两 甘草二两，炙
上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火微沸。下
火，先食温服五合，日三服，当微利。

【解析】本条论述太阳蓄血证治。

太阳表证不解，邪热入里与血搏结于下，发生如狂和少腹急结等证的，叫做太阳蓄血证。“热结膀胱”，可当做热结下焦血分去理解，亦可能是结于小肠之腑。手太阳小肠与手少阴心相表里，经脉相互络属，在下之浊热上扰心神，心神失守则其人“如狂”。“如狂”是精神症状，指患者的视听言动时慧时昧，然尚有别于打人毁物、骂詈不避亲疏之“发狂”。瘀热互结于下焦，气血凝滞而不通，故见“少腹急结”。“急结”是指疼痛、胀满、痞硬而急迫难耐，甚至痛苦不可名状。本证尚属邪热与血初结，热重而瘀轻，病势较为轻浅，故有“血自下，下者愈”的机转。因病在下焦血分，故瘀血多从大便而下。若不能自下者，则须用药物攻逐。但一定要注意，外有表证不解者尚不可攻，应先发汗解表，待表证解除后而少腹急结等里证不除者，才能使用桃核承气汤泄热逐瘀。

太阳腑证分蓄水和蓄血两种证候，都是太阳经表邪热不解而随经入里所致。然一在膀胱气分，而使气化失常，故必见小便不利；一在下焦血分，热与血相结，故神志如狂，因不关气分，所以小便自利。可见两者鉴别要点，乃在于小便利与不利和神志正常与否。

桃核承气汤系调胃承气汤加桃仁、桂枝而成。大黄苦寒，芒硝咸寒，功能泄热破结。大黄本可去瘀生新，但力尚不足，故加滑利之桃仁活血化瘀以破蓄血。桂枝辛温通阳行气，用于本方其意不在解表，而在理气通阳，通阳即可行阴，理气则能行血，血行而结散，则病自解。可见在寒凉药中酌加温热药，在血分药中稍配气分药，确实有其妙用。

本方临床运用并不局限于“热结膀胱”的蓄血证，而有着较多的适应证，特别是妇科疾病尤为常用。如瘀热闭经者，证见少腹硬痛，心情烦躁甚至如狂，投之每验。妇科的玉烛汤，由四物汤加大黄而成，但效果不如桃核承气汤。此方也可用于产后恶露不下，而见喘胀欲死或精神狂妄者。若以本方和桂枝茯苓丸交替服用，则可以治疗子宫肌瘤病。又如

胸腹胁肋疼痛，每逢阴雨寒冷痛势加剧，且有跌仆损伤史者，是为瘀血久停于内，使用本方则有祛瘀止痛之效。此外，通过临床实践，体会到若本方与大柴胡汤合用，凡是痛在两胁或胸腹两侧而属气血凝滞的实证，无论其部位在上在下，皆能获效，甚至冠心病、阑尾炎等都可治疗。由此可见本方适应范围之广，可云不胜枚举。

根据古人服药经验，病在胸膈以上者，应先进食后服药；病在心腹以下者，当先服药后进食。由于本证病位在下焦，且桃核承气汤又系下瘀血之剂，故必须空腹服药，方能更好地发挥药效。方后注所谓“先食温服”即是此意。

伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，**谵**语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。（113）

柴胡加龙骨牡蛎汤方：

半夏二合，洗 大枣六枚 柴胡四两 生姜一两半 人参一两半 龙骨一两半 铅丹一两半 桂枝一两半，去皮 茯苓一两半 大黄二两 牡蛎一两半，煅

上十一味，以水八升，煮取四升，内大黄切如碇子，更煮一二沸，去滓，温服一升。

【解析】本条论述少阳兼表里三焦俱病的证治。

伤寒时至八九日，误用下法，使邪气内犯少阳，而正气有所损伤。邪犯少阳，枢机不利，表里三焦之气不和，故出现了一系列复杂的病证：“胸满烦惊”，烦惊，有人认为应作惊甚解，犹如烦疼的意思一样，有人认为应作心烦与惊恐两个症状解，我们认为应以前者为是，本证以惊为主。少阳病本有烦，此处意在突出“惊”，而不在突出“烦”。惊，即惊怖不安，是一个精神症状。人之七情变化与五脏功能密切相关，肝病多怒，胆病多惊，可见“胸满烦惊”是因少阳之气不利而致。“小便不利”是太阳膀胱腑气不利。“**譫**语”是阳明胃气不和。三阳经气皆为不利，故见“一身尽重，不可转侧”。本病虽见三阳证候，但以少阳病证为突出，太阳、阳明证则是由于少阳枢机不利，影响所及而成。故治疗以柴胡剂和解少阳为主，并酌加他药以治兼证。

柴胡加龙骨牡蛎汤即小柴胡汤去甘草（方中当有黄芩，成本缺漏，应补之），用以和解少阳，祛除半表半里之邪；佐以龙骨、牡蛎、铅丹以镇胆气之怯而止烦惊；小便不利，故加桂枝、茯苓以助太阳气化而行津液；**譫**语则加大黄泻阳明之热以和胃气。于是三阳之气和畅，错杂之邪内外尽解。

方中铅丹有毒，须用纱布包裹入煎。临床曾有服本药而致铅中毒的报道，因此用量切勿过大，一般不超过5克，且不要连续长期服用，以免造成蓄积性铅中毒。现今有人用生铁落代之亦效。大黄在煎药时应后下为合法。

本条接续于上条蓄血证治之后，有互相对比以加强辨证的用意。其一，两条都有神志病证，上条言狂，本条言惊；其二，蓄血证属太阳见少腹急结，本条证属少阳见胸满，病位有上下之别；其三，蓄血证小便自利，本证小便不利；其四，上条属热与血结，病在血分，本条属少阳枢机不利，病在气分。

后世有不少注家抨击本条文义不清，难以解释。但日人丹波元简著《伤寒论辑义》则认为本条精神有指导临床的实际价值，特别是柴胡加龙骨牡蛎汤用于治疗胸满烦惊之证，确有疗效，不可轻易否定。根据有是证便用是方的原则，现今常用此方治疗一些精神或神经系统的疾患，如精神分裂症及癫痫等，并多能取得满意疗效。如曾治陈姓青年，因受精神刺激而患精神分裂症，每夜不能安睡，家人轮流陪守。曾服大量氯丙嗪之类镇静剂无效。切其脉弦，遂投本方，只进二剂则病证大减。据患者及其家属反映，初服汤药后即能安静酣睡，可见其疗效之卓著。还曾用本方治过一例十多岁的舞蹈病患儿，终日手舞足蹈而无休止。并还有烦惊等精神症状，遂试用本方以镇静安神，佐加胆星等祛痰之品，数剂后证情好转。

伤寒腹满^证语，寸口脉浮而紧，此肝乘脾也，名曰纵，刺期门。
(114)

【解析】本条论述肝乘脾的证治。

病从伤寒伊始，而又出现腹满^证语等证，这是太阴、阳明脾胃疾患的反映。若其脉沉实有力，则脉证相符为顺。今“脉浮而紧”，实即寓有弦脉之意，弦为肝脉，可知本病是脾胃之证而见肝胆之脉，此为肝胆之邪乘于脾胃所致，也即木克土，故“名曰纵”。纵，指肝胆之气放纵无羁，顺势而往。由于肝胆影响脾胃为病，故其治当刺肝之募穴期门，泻肝胆之有余，以解脾胃之围。

伤寒发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，其腹必满，自汗出，小便利，其病欲解，此肝乘肺也，名曰横，刺期门。(115)

【解析】本条论述肝乘肺的证治。

“伤寒发热，啬啬恶寒”，是皮毛受邪而属表证。然肺主皮毛，有宣发肃降、通调水道的生理功能。邪在皮毛，内舍于肺，肺气亦为之不利，津液不得输布，故口渴而小便不利。由于大渴贪饮，肺的制节不行，水道不通；且脾之运化失常，气机不利，故见腹胀满。诸证究其所因，既有肺的本身病变，又有肝旺犯肺的因素，即肝木反侮肺金之候。因金本克木而反受木侮，此为犯上而侮其不胜，故称之为“横”。横，指肝气横逆亢盛。治疗当刺期门，以泻肝之“横”气，使肺摆脱其侮而使功能恢复。外窍通则汗出，内窍通则小便利，故其病欲解。上条有“脉浮而紧”一句，而本条未言何脉，疑有缺文。

以上两条的主要精神，是运用五行学说，通过肝乘脾和肝侮肺的实例，来说明脏腑之间的病理联系，示人辨证应全盘分析，论治当求其

本。至于条文所描述的具体证候，可能有脱落不全之处，临床切不可拘泥。

太阳病二日，反躁，反熨其背，而大汗出，大热入胃，胃中水竭，躁烦，必发谵语，十余日，振慄、自下利者，此为欲解也。故其汗，从腰已下不得汗，欲小便不得，反呕，欲失溲，足下恶风，大便鞅，小便当数而反不数及不多，大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也。（116）

【解析】本条论述太阳病误火坏证及正复欲解的证候。

本条可分为两段解释。第一段从开始至“此为欲解也”，讲述火邪伤人虽重，但也有正复邪却作解之机。第二段从“故其汗，从腰已下不得汗”至文末，言误火后阳郁于上的各种见证。

太阳病二日，本不应见烦躁而反见之，意味着阳热有余，邪气欲传经入里。此时反熨其背。熨背，是古代火疗法的一种，民间有的用瓦烧热布包熨背，谓之“瓦熨”；有的用砖烧热布包熨之，名为“砖熨”，皆为发汗而设，用之不当可大汗出而津液伤。津伤则胃燥，胃燥则里热更盛，形成了阳明胃家燥热实证，故见躁烦谵语。若病至十余日后，由于饮食保养，胃中津液得复，正气来复，可从下利而驱邪热外出，正邪激争，则先见振栗，此与振栗战汗的道理相同，皆为阴复阳和，病将向愈之兆。

然而，当其病未作解时，还见有一系列变证。如“从腰已下不得汗”，即上身有汗，下身无汗，此因火热之邪主升而炎上，内攻之后阳气得其相助而郁结于上，不能下达，造成上盛下虚，上下阻隔之局势。阳热之气上逆故呕；阳气不能下达，而气化固摄无权，则既欲小便不得，又欲失溲，并见足下恶风；阳郁于上，津液不能下达，故大便硬结，不言而喻，烦躁谵语等证也在所必见。大便硬结时，则标志着津液不能还入胃中，反受燥热所迫而偏渗外出，故小便当数而且多。如今反不数不多，说明津液尚能还入胃中，以调节肠胃之燥，于是大便自下。津液与阳气并行不悖，当津液下达，大便通行时，阳气也得以下达，阳明胃气下流，由原来足下恶风转为足心发热，则其他诸证，也将随之而解。但由于阳气从上而骤下，头为诸阳之会，阳气下降，头中阳虚，常可发生短暂的不适应现象，即“大便已，头卓然而痛”。卓然，不平常也，指头痛而非同一般。

本条所举阳郁于上，阴阳偏盛偏衰的病变，并不局限于伤寒误火的坏证，临床上常见于其他杂病，观其证颇似下焦虚寒，往往稍一疏忽，

妄投温补，便致大误。论其治则，或泄热，或滋阴，或理气，或导阳下行，均可斟酌，唯独温补万不可用。曾于河北昌黎县遇一牧羊人，壮年男性，彪形大汉，当时气候暖和，却身穿棉衣。自述素来怕冷，医者多用温补，曾服附子每剂量达30克，但病情反重，即使炎夏也脱不下棉衣。视其两目炯炯有神，面色红润，不似虚候，诊其脉沉弦按之有力，舌苔黄，且伴心烦易怒，小便色黄，大便不畅等证。诊断为阳郁于内之证，方用大柴胡汤通其郁以疏达阳气，两剂后复诊已脱去棉衣，继服两剂竟获痊愈。

太阳病中风，以火劫发汗，邪风被火热，血气流溢，失其常度，两阳相熏灼，其身发黄。阳盛则欲衄，阴虚则小便难，阴阳俱虚竭，身体则枯燥。但头汗出，剂颈而还，腹满微喘，口干咽烂，或不大便，久则谵语，甚者至哕，手足躁扰，捻衣摸床，小便利者，其人可治。（117）

【解析】本条论述太阳中风误用火劫的变证及预后。

太阳中风，当用桂枝汤解肌发汗，方为治疗之顺，若误以火劫发汗，则为治疗之逆，必然变证蜂起。风为阳邪，火亦属阳，太阳中风用火劫发汗，必致阳热更盛，而使气血流溢，失其运行之常度。风火合邪，即所谓“两阳相熏灼”，其身必发黄。此之发黄与前述“风温为病……若被火者，微发黄色”之机理相同。阳热亢盛，伤于阳络，则见鼻衄；阴液不足，故小便难；火迫劫汗，不仅伤阴，而且耗气，阴阳气血俱虚竭，无血以濡润，无气以温煦，不能充肤泽毛，身体则消瘦枯燥。前句之“阳盛”者，是言其邪，此“阴阳俱虚竭”，是言其正。概念不同，不可混淆。

阳热之邪若从汗解，谓之“热越”。此因阳热盛，阴液虚，热不得越，不能周身作汗，故但头汗出，齐颈而还。邪热不得外越，便入内攻伐，聚于中焦，脾胃气机滞塞，则腹满；影响肺气不利则微喘；炎于上则口干咽烂；下结于肠中，则不大便；久则胃热扰心，故作谵语。若病情再重，甚者至哕。哕，即呃忒或呃逆，与一般胃气不和的暖气、噎气不同。此为胃津大亏，胃气将败之候。临床常可见到某些温热病晚期出现哕证，多是病至险境，病情垂危的表现。

四肢为诸阳之本，阳热炽盛，内乱心神，外实四肢，故手足躁扰，捻衣摸床。捻衣摸床，是神志昏愤之后的一种无意识的动作，即两手不自觉地反复摸弄衣床。病延至此，恶候叠见，可谓热盛阴伤已达极为严重的地步。此时若小便尚利，可知阴津尚未尽竭，化源犹存，仍有一线生机，还有救治的希望。如若小便全无，是化源已绝，则难以救治。

本条对火热之邪伤阴动血的病理变化和证候描述非常全面，而且也很逼真，实为临床经验的总结。说明《伤寒论》不仅重视阳气，而且也重视阴血。后世温病学家由此得到启发，从伤寒误用火法，认识到犹如温病误用麻桂辛温之害，又从火逆之害，认识到温热之邪最易伤阴的致病特点。因此学习本条，不要局限于火劫变证，应当扩大思维，深入理解其义。

伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳，必惊狂，起卧不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。（118）

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤方：

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 生姜三两，切 牡蛎五两，熬 龙骨四两 大枣十二枚，擘 蜀漆三两，洗去脚（赵本作腥）

上为末，以水一斗二升，先煮蜀漆，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

【解析】本条论述伤寒误用火劫而导致惊狂的证治。

伤寒脉浮，其病在表，当应发汗解表，而医生误用火劫迫汗，汗出过多，导致了“亡阳”。亡，在这里当失去讲；阳，指心阳。亡阳实指心阳亡失。因心为阳脏而主神志，汗为心之液，阳为心之神，汗出过多，心阳随汗外泄，阳虚不能养神，则心神浮越不敛，故发生惊狂、起卧不安的症状。“起卧不安”，当以赵本作“卧起不安”为妥。一般地说，服用麻桂辛温过汗，多亡肾阳；而用火法迫汗，则多亡心阳。亡肾阳的，当用四逆汤救治；亡心阳的，则非附子、干姜之所宜，而应以桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤温阳救逆为妥。

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤，简称救逆汤。是由桂枝汤去芍药加蜀漆、龙牡而成，本方去酸苦阴柔之芍药，则利于辛甘为阳，以急温心阳；用龙骨、牡蛎以潜镇浮越之神气；对于用蜀漆之义，尚有不同认识，有的认为散火邪，有的认为祛痰水。从本证病机和药理作用分析，当以后者为妥。因本证缘由心阳虚损，阳虚不能布化津液，则易生痰水，从而形成“亡阳夹痰”的病变，即虚中夹实的证候。蜀漆乃常山之苗，味辛苦而性寒，功效与常山相若，它有较强的截疟、催吐、祛痰作用。用于本方既能散火邪，又能涤痰开窍。据陈修园之见，方中龙、牡二药不仅镇惊安神，而且亦有化痰行水的作用，这种解释则使方义更臻完善。可见温复心阳、潜镇安神、消痰化水，是本方的功用所在。本方

蜀漆现今常用量为3~5克，注意水炒先煎，以减少其对胃的刺激而消除涌吐等副作用，无蜀漆者也可用常山代替。若以蜀漆与大黄黄连泻心汤及远志、菖蒲合用，治疗精神分裂症辨证属痰热上扰者，效果较好。服药后或吐或泻或吐泻俱作，吐则多为痰涎，泻之多为黏液，其后皆觉精神爽快而人即安定。

形作伤寒，其脉不弦紧而弱。弱者必渴，被火者必^譏语。弱者发热、脉浮，解之当汗出。愈。（119）

【解析】本条论述温病不可用火劫汗。

“形作伤寒”，指其证候类似伤寒，也有发热、恶风寒、头身痛等证，但病实非伤寒。因其脉不弦紧而弱，也不像伤寒之脉那般弦紧，而切其脉反为弱。这里的所谓脉弱，是与伤寒脉紧对比而言，并非其脉微弱。“弱者必渴”和“弱者发热”两句当联系理解，即指其人同时见有发热、口渴的症状。根据“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病”的辨证精神，可以判断本条所述的伤寒类证，就是属于温病一类。因为温病初起，邪在卫分也可有微恶风寒和脉浮的见证。温病在表，当用辛凉宣散解表之法，故谓“弱者发热、脉浮，解之当汗出愈。”若反用火疗之法劫汗外出，则既伤阴津又助阳热，以致发生神昏^譏语等坏证。

温病亦属热病之一，故为伤寒之类证。因其为感受温热邪气所致，其病变以阳盛阴伤为特点，所以忌用辛热药物与火攻之法，为了能做到准确无误的治疗，必须认真辨证、分清寒热，不可稍有疏忽。

太阳病，以火熏之，不得汗，其人必躁，到经不解，必清血，名为火邪。（120）

【解析】本条论述因火成邪，下伤阴络的坏证。

“火熏”属火疗范畴，是利用药物燃烧后所产生的热气，或药物煮沸后所产生的热气熏蒸人体取汗以治疗疾病的一种方法。使人卧于烧热的土炕上，覆以厚被而取汗的疗法，也当属火熏法之类。太阳病为邪在于表，本当以汗解，而医反“以火熏之”，熏后又“不得汗”（可见火疗之法有出汗或不出汗两种情况），由于不得汗出，致使阳热郁遏不宣，火邪不能外越而反内攻，故心神被扰，其人躁烦不安。病至七日，为太阳一经行尽之期，叫做“到经”，此时若正复邪却，其病当愈。如果“到经不解”，说明阳郁太甚，火热陷深。火热之邪下伤阴络，迫血妄行，故发生“清血”。“清”，同圉，厕所也。清血即便血的意思。因于火逆所致，故名为“火邪”。

脉浮热甚，反灸之，此为实。实以虚治，因火而动，必咽燥唾

血。（121）

【解析】本条论述火邪上伤阳络的咽燥唾血等证。

“反灸之”若移至“实以虚治”之后，文意较顺。脉浮而发热无汗，是表邪闭郁，阳气不宣的表实证。艾灸之法能温阳散寒，但多用于治疗里虚寒证，或寒湿痹证。今表实阳郁而反用艾灸，故谓“实以虚治”，犯了“实实”之戒。而使表邪更闭，阳郁更甚，火攻于内，上灼阳络，动血伤阴，故咽燥唾血。因于火而劫阴动血，故曰“因火而动”。

以上两条，一用火熏，一用艾灸，皆为被火之误。汗不得出，热不得泄，以致发生动血伤阴的变证。然一伤阴络而清血，一伤阳络而唾血，又各有上下的不同。

微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦逆，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。（122）

【解析】本条论述虚热证误灸的变证。

本条四字一句，注家称之为四字真言、四言诀等，有的认为这条出自王叔和之手，有的则考证为张仲景原文。若据钱熙祚的《脉经·跋》来看，可能还是张仲景旧作的原貌。

“微数之脉”，指脉数而无力，多主阴虚火旺。灸法宜于虚寒证不宜虚热证，故谓“慎不可灸”。倘若误灸，不仅不能治病，而灸火反成为致病的因素，所以叫“因火为邪”。火邪内迫，“则为烦逆”。烦者，热也；逆者，火也；“烦逆”即火热逆证之意。“追虚逐实”，即一面追其虚，而另一面又逐其实。“追逐”，有增加之意。阴本虚，反用灸火更伤其阴，谓之追虚；热本实，反用艾灸助阳增热，谓之逐实。追虚逐实的结果，则导致“血散脉中”。“散”即散乱、消散的意思，指气血受到损伤。为此，仲景告诫人们：灸火之气虽微，但内攻有力，可导致阴血难复，肌肤筋骨失却濡养，而形成肌肤枯燥，焦骨伤筋的严重恶果。“焦骨伤筋”虽有夸张，但火逆之害，确非同小可，不容轻视。

以上三条，都是因火动血，一为清血，一为唾血，此为血散脉中，三者比较，实以本证伤血最为严重。

脉浮，宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病从腰以下必重而痹，名火逆也。（123）

【解析】本条论述火痹证的形成及临床表现。

脉浮为病在表，应治以发汗解表。若误用火灸，则表邪闭郁，无从外出。灸能助阳，阳气因火灸而盛，壅郁于上不能下达，下部无阳以温

煦，故发生火痹证，即从腰以下沉重而麻痹。此与第116条“从腰以下不得汗”、“足下恶风”等证病机相同，皆为阳郁于上，阴阳上下不得交通所致。第122条言火逆伤血，本条言火逆病气，两条相互比较，有气血对比之义。

验之临床，这种病理变化不仅见于火逆为患，而且误用或过服温热之药，也可发生类似病变。如曾见一阳痿患者，众医皆以为阳虚，峻用附桂硫黄温热壮阳之品，但是越治越痿，颇为苦恼。经详询病情、细察脉舌，审断其证并非阳虚，实乃阳郁不达，实证见羸候之理，改用大柴胡汤合龙胆泻肝汤化裁，数剂而愈。

欲自解者，必当先烦，乃有汗而解。何以知之？脉浮，故知汗出解也。（124）

【解析】本条接续上条讲其病有自解之机。

病欲自解者，必有欲解的一定条件和反映，其条件是正气得复，邪气渐退而还于表，其反映则是“必当先烦”，即先发生心烦发热，然后汗出作解。此时，其脉必浮，是正气驱邪外趋于表的重要标志，也即是病欲自解的确凿证据。这种情况似同战汗，但不见寒战振栗，仅见烦热汗出。

烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤，更加桂二两。（125）

桂枝加桂汤方：

于桂枝汤方内，更加桂二两，共五两，余依前法。

【解析】本条论述烧针取汗引发奔豚的证治。

用烧针责令其汗，即强迫病人发汗，汗出腠理开，针孔被寒邪所袭不得疏散，故发生红肿如核。劫汗内伤心阳，阳虚阴乘，水寒之气乘虚上冲，则气从少腹上冲于心，发为奔豚。治法可外用艾灸针处之赤核各一壮，以温散寒凝之邪，内服桂枝加桂汤温通心阳，平冲降逆。

引发奔豚，有两种原因：其一，如《金匱要略》所说：“从惊发得之”，即奔豚病与精神因素有关。人一旦受惊，惊则气乱，心气散乱，君火不旺，失去镇摄与主宰之能，则下焦阴寒之气得以上犯。其二，正如本条所云：“针处被寒”，即寒邪从针孔而入，外寒引动人体内在阴寒之气，乘机上冲。简言之，一是受惊伤心气，二是感寒邪入里，此为病

发奔豚之病机。

曾治一崔姓妇，其证颇奇，自觉有一股气从两腿内踝，沿阴股往上冲动，至少腹则腹胀，至心胸则心悸胸闷，头出冷汗，精神极度紧张，有死的恐怖感，日作三四次，平时常服镇痛片，稍得缓解。兼见腰酸带下，面色青黄不泽，舌胖质嫩，苔白而润，脉弦数无力。辨析此病，亦当属奔豚，其气不从少腹而从内踝上冲，是为少见之证。遂用桂枝加桂汤，另服黑锡丹二钱，共服五剂而愈。

桂枝加桂汤即桂枝汤加重桂枝用量。据《神农本草经》记载，桂枝有治“三气”之功：即降逆气、散结气、补中益气。具体来说，其一是能下气。陈修园、张令韶等认为，桂枝能疏肝降逆，如苓桂术甘汤证，水气之所以上冲，即与肝气的激发与挟持有关。昔老中医陈慎吾用逍遥散，每以桂枝取代薄荷，使疗效提高，也是很有道理的。日本有的医家根据“气上冲”用桂枝的道理，认为“太阳病下之后，其气上冲者，可与桂枝汤”，当与本条的气上冲证联系理解，提出凡是上气之证都可酌用桂枝。其二是能开结气，如桃核承气汤用桂枝，便是取其通阳开结以散蓄血之用。又如临床治疗“梅核气”，用半夏厚朴汤不能取效时，若加桂枝则可见功效，亦可证明桂枝既能下气，又能开结。其三是能补中益气，如桂枝甘草汤能温补心气，桂枝汤可以调和脾胃以建中气，而本方重用桂枝，也正是为了加强补心、通阳、下气的作用，故用之治奔豚，最为合宜。

临床常见某些心脏病患者，可出现奔豚气的证候，其人自觉气上冲胸时，便发生期前收缩、心律不齐、心悸、憋闷、窒塞等症状，用本方治疗效果满意。此外，又据空军某医院大夫介绍，有一患者病发奔豚，当气从少腹上冲至心时，则发憨笑，笑后心里颇觉难受，体不能支，竟用本方四剂治愈。

有的注家对本方“加桂”有不同的见解，一云加桂枝，一说加肉桂。根据原文“更加桂二两”之意，当是指加桂枝而言，但从临床应用来看，加桂枝或加肉桂同样有效。

火逆，下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。（126）

桂枝甘草龙骨牡蛎汤方：

桂枝一两 甘草二两 牡蛎二两，熬 龙骨二两

上为末，以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，日三服。

【解析】本条论述火逆而致心阳虚烦躁的证治。

“火逆下之”，“下之”，不好理解，有的注家认为是衍文，当删；有的认为可能是“汗之”之误，即火逆发汗之意。两说均有一定道理，均可从之。本证由于烧针火逆，损伤心阳，以致心阳虚不能敛养神气，使心神浮越，而发生神情烦躁不安等证，此比第118条误火惊狂证为轻，也可谓是惊狂之轻证。故用桂枝甘草加龙骨、牡蛎温复心阳，潜镇安神。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤用桂枝甘草温复心阳，加龙骨、牡蛎潜敛神气以止烦躁。临床应用本方不必局限于火逆之误，凡心阳虚而见烦躁等证均可施治。

太阳伤寒者，加温针，必惊也。（127）

【解析】本条简要概括火逆的证变。

温针，与火针同类，皆属火疗之法，施治于太阳伤寒病，迫劫发汗，显然是治不顺理，因之使人“必惊”。此言“惊”，主要不是讲证情，而是指一种惊恐的心理状态。因为温针之类的火疗，是人为的外在刺激、强力迫汗之法，使人望而生畏，畏而必惊。惊则心气伤、胆气乱、正气馁，气血阴阳俱受影响而失其常度，使邪气有可乘之机，从而为多种变证的发生提供了一定条件。因之诸如奔豚、惊狂、烦躁等各种病证，便可由此而起。所以日人山田正珍提出：本条文应列于上述诸条火逆证治之首，而具有提纲的意义，此说颇有道理。当然本条列于以上诸条之尾，以作总结之用，也未尝不可。

以上介绍了12条火逆证，现简要小结如下：

火疗，是我国古代一种物理疗法，汉时颇为流行。其中包括熏蒸、烘熨、烧针（火针）、温针、灸法等等，具有发汗、散寒、通阳、开痹的作用。它有着严格的适应证和禁忌证。若用于脘腹冷痛、风寒湿痹、虚寒下利以及外科痈疽疮疡等证，只要方法得当，确有较好的疗效。倘若误施于其禁忌病证，如以上12条所述诸病，必然导致各种变证，即所谓“火逆证”。张仲景列举多种火逆证，着重指出误火之弊，使后人从中吸取教益。

然而，如今随着科学的发展，上述原始的各种火疗方法已渐淘汰或被改革，来自火逆的各种变证也几不复见，但并不是因此就失去了学习火逆诸条的意义和价值。现在重温仲景昔日旧论，不要消极地就事论事，而拘泥于原文之中，应该积极地扩大辨证思维，跳出条文之外。这样才能认识和理解《伤寒论》火逆证治的实际价值和现实意义，这也就

是我们必须坚持的“古为今用”的原则。如通过学习，可以了解到，伤寒外感热病若误用火疗，必致火逆变证。由此引申其义，凡阴虚之体或温热病患者，切不可误用辛温燥烈之药，否则伤阴动血，也在所难免。同时，诸条火逆证所表现的气血受伤，阴阳失调的病理变化及证候特点，如上见唾血，下见便血，血散脉中，阳郁于上不能下达，而见腰以下不得汗必重而痹，足下恶风等，往往在临床许多疾病中都可以见到。因此，研究并探讨这些具有普遍临床意义的病理机制、证治法则，并以此作为借鉴，将有助于提高我们辨证论治的水平。此外，仲景所出三方，如救逆汤、桂枝加桂汤、桂枝甘草龙骨牡蛎汤，一直被后世医家广为习用，并在运用中有所发挥，使古方获得了新的生命力。这就是我们今天仍要很好地学习“火逆”诸条的目的和意义。

太阳病，当恶寒发热，今自汗出，不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一二日吐之者，腹中饥、口不能食；三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。

（128）

【解析】本条论述太阳病误吐而致胃气虚寒的证候。

太阳病为表证，当见恶寒发热，而现在病人表现自汗出、不恶寒也不发热，说明表邪已解。切其脉出现关上脉细数，关脉候脾胃，细数即数而无力，似乎是胃家虚热之证，实际上这是胃气虚寒的一种假热之象。为何表证已解，反而又见关上脉细数呢？原来这是医生误用吐法，损伤胃气之过。

原文中所云：“一二日”或“三四日”，仅是约略之词，不要过于拘泥具体日数，当理解为病程有长短之别，证情有轻重之异，因而误吐之后的变逆也有大小的不同。“一二日吐之者”，谓其胃气伤害轻浅，故尚能知饥而仅口不能食。“三四日吐之者”，言其胃气伤害稍重，因胃虚而有假热，故欲进冷食。但其本质是胃气虚寒，不能对食物腐熟消化，故朝食而暮吐，或暮食而朝吐，与食已即吐的胃热证绝然不同。太阳病不当吐而用吐法，是属误治，但由于吐法寓有向上向外发散的效能，故吐后表邪得解而无内陷之患；且其变逆仅局限于胃腑，故称之为“小逆”。

太阳病吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣，此为吐之内烦也。（129）

【解析】本条承上文论述太阳病误吐而致胃气燥热的证候。

太阳病的桂枝证，有时出现气上冲咽等证，若误为痰实而妄用吐法，使其证由恶寒变为不恶寒，说明了表邪已解。但是又出现恶热而不欲近衣等新的证候，这反映了误吐之后，损伤胃中津液，胃气燥热，故

谓之“内烦”。内，里也，在此指阳明胃；烦，热也，在此指阳明之里有热。第71条“发汗后恶寒者，虚故也；不恶寒但热者，实也，当和胃气，与调胃承气汤”，与本条机理有些相似。事物总是一分为二的，联系前后条文可以看出，发汗后恶寒者为阳虚，不恶寒但热者为胃热燥实。误吐后也有两种变局，一是上条的胃气虚寒而有假热；一是本条的胃气燥热而见内烦。对比之下，则寒热虚实的辨证要点自然明确于胸。

本证论治，可仿第71条的少与调胃承气汤，微和胃气之法。

病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。（130）

【解析】本条论述汗后胃寒致吐的脉证机理。

病人脉数，数主热，热能化物，本当消谷引食。而今反见呕吐，此为发汗后致“令阳气微，膈气虚”，即胸膈胃脘的阳气因误吐而致不足所造成。在这种情况下出现的数脉，绝非实热之可言。况且脉数而按之微弱，这种数而无力的脉象，正反映病的本质是“胃中虚冷”。“数为客热”，即言“热”为假象，胃气虚寒而生的“客热”是不能消化水谷的，因而症见不能食或食后谷不化，寒气上逆而作呕吐。

《濒湖脉学》在讲到数脉主病和论治的时候说：“实宜凉泻虚温补”，即数而有力的实热证，宜用凉药以泻火；数而无力的真寒假热证，当用温补之法。本条未出治法与方药，根据其“胃中虚冷”而致吐逆的病变特点，可考虑用理中汤加丁香、吴茱萸，以温中补虚，降逆止呕为宜。

太阳病，过经十余日，心下温温欲吐，而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦。先此时，自极吐下者，与调胃承气汤。若不尔者，不可与。但欲呕，胸中痛，微溏者，此非柴胡证，以呕故知极吐下也。（131）

【解析】本条论述太阳病过经传变与误用吐下致变的证治，兼论与小柴胡汤证的鉴别。

本条可分三段作解。第一段从太阳病开始至“郁郁微烦”，论太阳之邪渐次向里传变，由胸及腹的见证；第二段从“先此时，自极吐下者”至“若不尔者，不可与”，言误经极吐下，胃气不和的证治；第三段从“但欲呕”至结束，言本病虽类似少阳但实非少阳证，故不可用小柴胡汤。

太阳病，已过经十余日，表邪有往里传变的机转。因胸为太阳之

分，故邪气传里而必先胸。邪在胸膈，则心下温温欲吐。“温温”似当改为“愠愠”，读晕，即心中烦闷不舒畅的意思。胸间气机不利，则胸中作痛。邪热内入，影响里气不和，则发生腹微胀满和郁郁微烦。若已热结成实，大便必然干燥，而今大便反溏，说明热邪尚未聚结成实。由于是传经之邪渐次入里，仍未全离太阳，故虽有里热见证，亦不能下之过早而用调胃承气汤。

假设在太阳病未过经传变之前，就曾重用吐下之法治，而出现类似上述的诸证，情况那就不同了。因为病在表而误用吐下，则必伤其胃气，损耗津液，使邪热内陷而形成胃家实证。胃实当用攻下之法，但因胃气已为吐下所伤，故又不宜峻下，唯当和其胃气而已，故与调胃承气汤。“若不尔者，不可与”，是仲景再次强调，上述诸证若非因吐下所致者，则不可与调胃承气汤。

最后一段是作者自注之词。概括以上两种证候，都有欲呕、胸痛、微溏，颇似少阳病的小柴胡汤证。但无论是太阳传经之邪，还是极吐下所致的胃不和，其病变都不在少阳胁下部位，故不可误投小柴胡汤。尤应注意的是，切勿以“欲呕”一证，与少阳的“喜呕”相混淆，本病欲呕是胃气受伤之见证，是为极用吐下之所伤，而与少阳证丝毫无关。

太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞭满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也。抵当汤主之。（132）

抵当汤方：

水蛭三十个，熬 虻虫三十个，熬，去翅足 桃仁二十个，去皮尖 大黄三两，酒浸

上四味为末，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下再服。

【解析】本条论述蓄血重证的辨治。

文中的“抵当汤主之”，当移至“下血乃愈”之后。太阳病六七日，表证仍在，为何出现“脉微而沉，反不结胸”？有的注家提出，“表证仍在”之后，当有“而反下之”一句，这样才与下句“反不结胸”衔接自然而合乎常理。因为本论有“病发于阳而反下之，热入因作结胸”的论断，即太阳在表之邪不解而误用泻下，往往引起邪气内陷而形成结胸证，这样，脉也随之由浮而变沉。但今反不结胸，而其人发狂，出现打人毁物、不避亲疏等证，说明太阳邪热未陷于胸，而是随经入腑，深入下

焦，与血搏结形成的太阳蓄血证。太阳蓄血，热与血结于下焦，故而“少腹鞭满”。硬者，坚硬也，医者可触按而知；满者，胀满也，为患者的自觉症状。病在血分，无关于气化问题，故小便自利。

太阳之邪随经入腑，可形成蓄水和蓄血两类病变。蓄水者，小便不利；蓄血者，小便自利，故两证有别而辨识不难。但蓄血证又有轻重之别，若热与血初结而热重于瘀者，证见“少腹急结”，病势较为轻浅，尚有“血自下，下者愈”的机转；若血不自下者，则用桃核承气汤下之。至于本证则是热与血久结而瘀比热重，证见“少腹鞭满”，瘀已成形，势为深重，故非下不可，当用下血峻剂抵当汤。“所以然者”，是作者自注句，言知其然，也应知其所以然，是太阳在表，邪热随经入里，与血相结于下焦的缘故。

抵当汤之所以名“抵当”，解释不一。有人认为，这种下焦蓄血重证，非他药所能及，唯有此四药足以抵当而攻克之，故名曰抵当汤。有人则反对此说，认为若因其方峻猛而命名，那么十枣汤、大陷胸汤攻逐之力，也非比一般，而为何不名冠“抵当”呢？然据考究，方中水蛭，古又名“至掌”，故也有医家称此方为至掌汤，而后人讹称抵当汤。我们则认为对于方名的原义不必过细考证和追究，重点应在于掌握其方义及临床适应证。

抵当汤为破血逐瘀之峻剂，既有大黄、桃仁的植物药，又有水蛭、虻虫的动物药，其遣药组方可谓是集活血化瘀之大成，非一般活血剂所能比拟。水蛭味咸，虻虫味苦，二药相配，破血之力尤峻，又得大黄泄热逐瘀以推荡，桃仁行血化瘀以滑利，可奏血下瘀行，诸证尽愈之效。应注意水蛭不可生用，原文云“熬”，即是水炒入煎。虻虫去翅足，也当炒用。服汤后，“不下再服”，意在言外，得下则止后服。

本方在临床可治疗多种气血瘀结的病证，有时疗效十分满意。下面略举几例治验以作证明。

魏姓女，30岁，河南人，于1969年患精神分裂症，曾住院接受电疗和胰岛素治疗，病虽有减，但未痊愈而出院。终日自觉头皮发紧，犹如有道铁箍。记忆力严重衰退，言听视动随过随忘，双目呆滞，表情淡漠，经期少腹疼痛，舌质略暗，苔略腻，脉沉滑。据《内经》云：瘀血在下，使人发狂，瘀血在上使人善忘，遂诊断为瘀血证。治用本方以活血逐瘀，佐加柴胡、半夏以疏肝去痰，处方为：桃仁12克，生大黄10克，炒水蛭、炒虻虫各6克，柴胡、半夏各10克。二剂后稍见泻下，证有所减，复诊转方：桃仁12克，大黄、丹皮各10克，茯苓24克，桂枝、赤芍、蒲黄、五灵脂各6克。二剂后泻下臭秽之物甚多，头紧如箍感顿

时松解，喜忘证大有好转，表情也转活跃。自诉其病已愈十之七八。要求带药回老家调治，遂拟桃核承气汤加菖蒲、郁金持之而归。

刘姓女，37岁，二年前因产后感冒，随即发生眼睛疼痛，失眠。从此右眼视力开始下降，从1.2降至0.1，经眼科检查，确诊为中心性视网膜炎。治疗后右眼视力恢复到1.0，而左眼视力反从1.5降至0.1，检查眼底有水肿。某中医给予石斛夜光丸，服后视力有所上升，左眼视力达0.8，右眼为1.2。但继而出现后背及右少腹疼痛，经期两腿发胀，腰腹俱痛，精神紧张，惊怖不安，善忘，六脉弦滑，舌质绛暗，舌边有瘀血斑，据脉证表现，初步辨证为：气血瘀滞，瘀浊上扰心神。因其视力已有好转，故未加以特别注意。遂用本方佐加白芍、丹皮以平肝。处方为：桃仁15克，大黄、丹皮各10克，白芍、炒水蛭、虻虫各6克。病人复诊时述，服汤药后约六七小时，发生一种异常反应：脑后跳动疼痛，腹痛难耐，随即大便泻下颇多，小便犹如血汁，其后诸痛迅减，周身轻松如释重负。特别感到惊奇的是视力也觉大有好转。又转方用血府逐瘀汤加茺蔚子、决明子，服药六剂后，复去眼科检查，认为由于黄斑区棕褐色变浅变小，而使视力上升。三诊：继用血府逐瘀汤，加蛭螭、土鳖虫、鸡血藤、茺蔚子等，终获痊愈。

又例，王姓少女，曾患精神分裂症，经住院治疗好转。但后因闭经两月，病复发，显然证属瘀血，遂投抵当汤一剂，药后血下神安。

最近有人介绍，运用本方治疗冠心病取得效果，说明其不仅可以治下焦蓄血，而且可治上焦心脉瘀血。方用之广、效应之验，不胜枚举。

太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之。（133）

【解析】本条补述蓄血证可继发身黄，以及它与湿热发黄不同的辨证。

太阳病，是其发病之来路。脉沉结，沉主病在里，结即脉跳缓而有歇止，为气血凝滞不利之象。身黄一证，应当区别湿热与瘀血两种因素，虽然两者都可出现身黄，以及脉沉结、少腹硬的共同脉证，但仍有其各自不同的鉴别要点。湿热发黄，其色黄而鲜明如橘子之色，小便不利，可有心烦，但无发狂。瘀血发黄，其色黄而晦暗不泽，小便自利，且见发狂之证。文中“如狂”的“如”字，柯韵伯认为是助语辞，不作“象似”解，“如狂”，即“如果发狂”之义。小便自利，其人发狂，这都是鉴别湿与血的辨证眼目，也就是说，对身发黄，脉沉结，少腹硬的病人来说，更见小便自利，其人如狂，则蓄血证已确信无疑，故曰“血证谛也”。“谛”，音帝，证据确凿之意。治用抵当汤攻逐瘀血。

伤寒有热，少腹满，应小便不利；今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。（134）

抵当丸方：

水蛭二十个 虻虫二十五个 桃仁二十个，去皮尖 大黄三两

上四味，杵分为四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之，晬时，当下血；若不下者，更服。

【解析】本条再论述蓄水与蓄血的鉴别要点，并提出蓄血证的缓治法。

病由伤寒发热而起，续发少腹胀满，若为蓄水所致，则小便会不利，今小便反利者，则知非是蓄水，而是蓄血，治当攻下瘀血。因本证仅见“少腹满”，未见少腹硬，也未见如狂或发狂，说明热与瘀都较轻。因其热势不如桃核承气汤证之甚，瘀势也不如抵当汤之重，故用丸剂缓攻为宜。

抵当丸即抵当汤原方改而为丸，药虽峻烈，但一剂分四丸，每次仅服一丸，而成峻药缓用之法。服药采取“煮丸之法”，连药渣一并服下，故云“不可余药”。考本论大陷胸丸的煎服法也是如此。因丸药性缓，其下瘀血之力比汤药和缓而作用持久，故服药后“晬时当下血”。晬时，周时也，即一昼夜的对头时间。若不下者可再服。考抵当汤方后注云“不下再服”，可见汤剂服后，不待晬时而是在短时间内即可泻下。

有报道说用抵当丸治疗妇女子宫肌瘤曾取得疗效。《金匱要略》中有一下瘀血汤，即是本方去水蛭，改虻虫为蟅虫，主治产后瘀血腹痛，服药后下血如猪肝状，其病则愈。

以上数条，说明热与血结的蓄血病，证有轻重之分，治有缓急之别。简而言之，其热重于瘀者是桃核承气汤证；瘀重于热者是抵当汤证；瘀热皆轻者是抵当丸证。

太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸。小便少者，必苦里急也。（135）

【解析】本条再论太阳蓄水，与上条蓄血证治并列，而有鉴别之义。

在患太阳病的病程中，若患者饮水过多，可发生伤水的病证。如果

膀胱气化功能尚好，小便通利，而脾胃运化机能较差，则饮水过多，每易导致中焦停水，证见心下悸动不安等，当以茯苓甘草汤主治。如果膀胱气化功能低下，小便少而复被水伤，必致下焦蓄水，证见少腹胀满难耐，所谓“必苦里急”是也，当以五苓散主治。可见太阳蓄水的病因有二：一是太阳随经之热入里，影响膀胱气化功能，水液不行，小便不利而蓄水；一是在患太阳表证期间，膀胱气化功能低下，此时若饮水过多，膀胱不及气化，则水蓄于下焦而“必苦里急”。

【小结】

本篇原文共104条，主要论述了葛根汤证、麻黄汤证及其加减证，并补充了桂枝汤的治疗范围。文中除了关于解决太阳不同类型的表证的辨证与治疗外，还在误治变证之前先提出“阴阳自和，必自愈”的治病原则，以指导误治后所出现的心、肺、肝、脾、肾等寒热虚实种种变证的救治。其名为辨误治变证，而实含有治疗杂病的成分在内，羽翼了六经辨证的不足。其后又论及太阳经邪入腑，经腑两病的五苓散证；火郁虚烦的栀子豉汤证；阳虚水泛的真武汤证。水火寒热互相比，更具辨证的意义。至于所提出的表里先后，表里缓急的治疗原则，误火、误吐、误下等所发生的种种坏证的救治，对临床治疗都有一定的指导意义。同时还论述了太阳邪传少阳的小柴胡汤证及其加减、禁忌之法，以示太阳之邪传里。若津伤者则传阳明；若气弱者，则可直传少阳。最后又论述了太阳病蓄血证治，并与太阳腑的蓄水证作了鉴别比较。至此就把太阳的经表证与太阳的腑证都作了全面的论述，从而形成太阳为病的辨证论治理论体系，使临床治疗有客观规律可循。

辨太阳病脉证并治法下

【概说】

下篇内容，承续于中篇而与之有机联系。前已讲述栀子豉汤证，是太阳表热内传于胸，仅为火郁而无痰水等有形之邪，故谓之“虚烦”。下篇之始，即论结胸证，它的成因，也是太阳邪热内陷于胸，甚或由胸传至心下，属内陷之邪与痰水互相凝结而成的一种病证。结胸有不同类型，因其病势有浅深之分，病位有上下之别，病性有寒热之异，故有大结胸、小结胸、热实结胸、寒实结胸之名，此为下篇主要内容之一。其二，还介绍一些结胸的类证，即类似结胸而实非结胸，如脏结、太少并病、热入血室等证，都有“如结胸状”的表现，故列于其后，以作互相对比、鉴别，从而扩大辨证论治的范围。其三，继结胸证治之后，又论由于误下，损伤中焦脾胃之气，致使阴阳升降发生紊乱，因而形成心下痞证。有关心下痞的证治，亦是本篇重要内容之一，它列于结胸之后，则有虚实对比之义。其四，太阳之邪不解，从阳化热，内传阳明，从而引出邪热弥漫充斥表里内外，然尚未燥结成实的白虎汤和白虎加人参汤证。在中篇论述了太阳之邪传少阳的证治，本篇又论述了太阳之邪内传阳明的证治，从而说明太阳之邪既可传少阳，也可传阳明，并无固定规律可循，临床应当凭脉证进行辨识。

问曰：病有结胸，有脏结，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。何谓脏结？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰脏结。舌上白胎滑者，难治。

（136）

【解析】本条采用问答形式，通过结胸与脏结主要脉证的对比，来阐明何谓结胸，何谓脏结，以及两者的鉴别要点。

结胸与脏结，虽都有相类似的心下硬满疼痛的症状，但其病机有阴阳寒热的不同，其脉象和其他证候也有所区别。从病机来看，结胸是阳热与痰水凝结于胸中，虽以胸中为主，但有时病位较广，可涉及腹部，其病性属阳、属实，为实热证。脏结多为脏虚阳衰，复被阴寒所凝，其病位在脏，其病性属阴、属虚，为虚寒证。再看脉象，结胸是寸脉浮，关脉沉。寸脉浮是言其病之来路，即太阳表邪误下之后，由表经胸入里而与痰水相结；关脉沉，是为里有水之征。脏结是寸脉浮，关脉小细沉紧，因其病之来路也是太阳误下，故寸脉浮，证属脏虚，所以关脉小

细，而沉紧则主寒邪凝结之象，即脏气虚而寒气结的病变，故名曰脏结。症状对比：结胸为热实之邪壅于内，故多不能食，而大便秘结；脏结是寒结于脏，胃腑无实邪壅滞，故饮食如故。然而，脏为寒结，脾阳不运，水谷不别，所以还有时时下利之证。如果察舌苔，二证也不相同：结胸舌苔虽未明言，但据证推理，其苔多为黄燥；脏结舌苔白滑，反映阳气虚衰而寒凝不化，证属正虚邪实。由于寒结之实非攻不去，而脏气之虚又不能攻，故为“难治”之证。但难治不等于不治，临床犹可采用温化寒结之法。

本条虽以结胸与脏结并列而论，但作者写脏结的意义在于烘托突出结胸的辨证，这是“假宾定主”的笔法。通过对结胸、脏结二者的脉证对比，以加强辨证认识，且寓有举一反三之妙义。

通过对《伤寒论》的学习，可以看出张仲景的文章格式有三种不同体例：一是条文式；二是四言诀式；三是问答式。以上三种体例皆为汉时所习用。可见张仲景不仅医术精深，而且也很会写文章，可谓文以载道而医文并茂。

脏结无阳证，不往来寒热，其人反静，舌上胎滑者，不可攻也。
(137)

【解析】本条承上文，补述脏结的症状和治禁。

脏结与结胸不同，“脏结无阳证”，即无发热恶寒的太阳表证；“不往来寒热”，是说无少阳证；“其人反静”，谓无阳明病的烦躁证。因邪热在里属阳明证者，必见烦躁，而今其人神情安静，故邪不在阳明。既然三阳经证候俱无，就排除了病在六腑而发于阳的问题。脏结是阴证，是脏虚阳衰，阴寒凝结之证，故见阳虚津液不化“舌上胎滑”之象。上条曰“难治”，本条曰“不可攻”，正因其邪实而又不可攻，故谓之难治。

此证仲景未出方治，有的注家提出用理中汤加枳实，以理中汤温补中阳，以枳实破气散结，可资参考。

病发于阳而反下之，热入，因作结胸；病发于阴而反下之，因作痞。所以成结胸者，以下之太早故也。(138)

【解析】本条论述结胸与痞证的成因。

“病发于阳”，是病发于阳经。据“发热恶寒者，发于阳也”之文意，可知病发于阳即指太阳而言。邪在太阳而反下之，造成表邪入里而变热，邪热与痰水相结于胸，故成结胸证。

“病发于阴”，即病发于里，里证有可下的，也有不可下的，如阳明燥热里实证则可下，若是中寒里虚证则不可下。若不可下而误下，必伤

脾胃之气，使之阴阳不和，升降失调，气机痞塞，故作心下痞证。如“太阴之为病……若下之，必胸下结鞕”，即言太阴脾胃虚寒证，是病发于阴，误下之后，可发生胸下痞硬。又如少阳病的小柴胡汤证，虽是阳经病，但它属半表半里证，已有里证的成分在内，故误下之后，也可出现痞证。

夫结胸言“热入”，是指误下后表热内陷；痞证则不言“热入”，是因为其本是里证而无外邪之故。“所以成结胸者，以下之太早故也”，为自注之文，是说结胸证虽应泻下，但不可下之太早，邪犹在表而过早攻下，反致邪陷热入而续发结胸。至于痞证本属里虚，终无可下之理，故也谈不到下之迟早了。

以上三条简要介绍了结胸、脏结、心下痞的成因和主要脉证，对以下诸条有着指导意义，其详细证治，则见于以下诸条。

结胸者，项亦强，如柔痉状。下之则和，宜大陷胸丸方。（139）

大陷胸丸方：

大黄半斤 葶苈半升，熬 芒硝半升 杏人半升，去皮尖，熬黑

上四味，捣筛二味，内杏人、芒硝，合研如脂，和散，取如弹丸一枚；别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升，温顿服之，一宿乃下，如不下更服，取下为效，禁如药法。

【解析】本条论述结胸证而病位偏于上的证治。

凡结胸证，必心下硬满疼痛。此言“项亦强，如柔痉状”，痉，同痙。痙病其中有汗者称柔痙，无汗者称刚痙。据此可知，本条所言之结胸证，除有心下硬满疼痛之外，尚有颈项强直、能仰不能俯、汗出等类似柔痙的临床表现。此为热与水结而病位偏高，邪结高位，项部经脉受阻，津液不布，经脉失其所养，故出现项强如柔痙的样子。由于在里之水热蒸腾，且阳气内陷而不能外密，故见汗出。治用大陷胸丸攻下水热之结。水热去，心下硬满疼痛等证自可消除；津液通达，水精四布，则项亦不强而转柔和。故曰“下之则和”，宜用大陷胸丸。

大黄、芒硝、甘遂三药相伍，名为大陷胸汤。今变汤为丸，又加葶苈、杏仁、白蜜叫大陷胸丸。方中大黄、芒硝、甘遂合用，相辅相成，既可攻泻邪热之鞕坚，又能荡涤积聚之痰水，此为本方之主要药物。因本证之邪结不仅在于心下，而且包括胸膈，甚至上及项背，以致出现胸

胁硬满疼痛、短气喘促等肺气不利的证候，故加用葶苈以泻肺，杏仁以利肺，务使肺气开豁疏利，水之上源宣达畅通，其凝结于高位的水热之邪，必将随之而下，而荡涤无余。本方药虽峻利，但由于采用煮丸之法，硝、黄、葶、杏四药合研，仅取如弹丸一枚，用量不大，且方中有白蜜，味甘而缓，使泻下之力，留于上焦，缓缓发挥作用，不致因下之过猛、过急，而有遗邪于上的弊端，因此，本方可谓峻药缓行、以攻为和的代表方剂。所以方后注云：药后“一宿乃下”，与大陷胸汤之“得快利”相较，显然丸缓而汤峻。方名“陷胸”者，是因为胸为高位，有邪当陷下以平之。

结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。（140）

【解析】本条论述结胸证脉浮大者不可下。

结胸证，脉见浮大，脉浮为表邪未全入里；脉大，是里未成实。此时虽有心下硬满疼痛，但由于脉不沉紧为脉证不符，故不可用大陷胸汤攻下。若误下之，必伤里气，反引邪入里。正气先衰，邪气复结，正虚邪实，攻补两难，预后不佳。若结胸证脉见浮大无力，则更属正虚邪实之候，不顾正虚而妄下，犯虚虚之戒，可使正气亡脱，故曰“下之则死”。结胸证不可不下，然亦不可下之过早，下之过早则预后不良。

结胸证悉具，烦躁者，亦死。（141）

【解析】本条承上文论述结胸证当下不下而见烦躁的危候。

“结胸证悉具”，是谓结胸诸脉证皆已具备，如心下或从心下至少腹硬满而痛不可近，短气烦躁，心中懊恼，脉沉实等证，此时当急用大陷胸汤，因势利导，泄热逐水则愈。若在这种情况下，医生畏首畏尾，不能果断地采用泻下之法，致使病程迁延，邪气锢结更深，正气削弱益虚，在邪盛正衰之时出现烦躁，则属于真气散乱、正不胜邪的一种危候，与阳热内盛而致的烦躁根本不同，故预后多为凶险。由于上条有“下之则死”，本条承接上条，故有“亦死”之言。但在今天的医疗条件下，积极救治，也并非都会死亡。

以上两条，皆论结胸证之预后，前后联系体会，其义更备。前者是失于孟浪，不应下而下，下之过早；后者是过于谨慎，应下而未下，治不及时。一为误治，一为失治，然后果不良则一。因此，学习这两条，应从中吸取教益，临诊治病应密切观察病情，抓住治疗时机，才能取得满意疗效而不致发生误治、失治的问题。

太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，数则为虚，头痛发热，微盗汗出而反恶寒者，表未解也。医反下之，动数变

迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊^怏，阳气内陷，心下因鞅，则为结胸，大陷胸汤主之。若不结胸，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄也。（142）

大陷胸汤方：

大黄六两，去皮 芒硝一升 甘遂一钱

上三味，以水六升，先煮大黄，取二升，去滓，内芒硝，煮一两沸，内甘遂末，温服一升，得快利，止后服。

【解析】本条论述误下太阳而成结胸或发黄的变证。

本条分三段解释。第一段，从“太阳病”至“表未解也”，讲的是从脉证分析而知表邪未解；第二段，从“医反下之”至“大陷胸汤主之”，论误下后形成大结胸的证治；第三段，从“若不结胸”至全文结束，论误下后形成湿热发黄的变证。

“太阳病，脉浮而动数”，脉动，在这里不是指“动”脉，而是指脉搏躁动的意思，也就是其脉浮而躁动数急。浮主风邪在表，动数主热，肌表有风热之邪，身体必有所疼痛，故云“动则为痛”。数脉虽主热，但其热并未与体内有形之实邪相结，故谓“数则为虚”，可见这里的“虚”，并非正虚之“虚”，乃是里无实邪之意；“头痛发热”，是属表证，但见“微盗汗出”，则反映阳热之邪较盛，且有入里的趋势。因为寐则卫气行于阴，阴者里也，卫气行于里而使里热外蒸，表气不固，则盗汗出；此时若表邪已尽入于里，则恶寒必罢，今仍头痛发热而反恶寒，则说明“表未解也”。既是表未解，虽有里实之热亦不可下，故“下之”曰“反”。如医反用下法，则使邪气内陷，结于胸膈，故脉由动数变为迟缓。喻嘉言说，迟“有结而难开之象”，所以脉迟是邪气凝结的反映。邪陷入里，正气与之拒抗相争，故“膈内拒痛”。胃气因误下而虚，邪气乘正虚而动犯胸膈，是谓“胃中空虚，客气动膈”。胸为气海，受邪则气机受阻，故见“短气”。胸为阳位，心居其中，邪热内扰，故烦躁而至懊^怏，以上诸证，皆是阳热内陷与痰水相结而致结胸的病变反映。而“心下因鞅”，则知结胸主证已备，故当以大陷胸汤泄热逐水。

亦有虽经误下而不成结胸，导致湿热郁蒸者，则是另一种病变机转。热为阳邪，欲外越而从汗出，但因湿之黏腻纠缠而不得宣泄，故“但头汗出，余处无汗，剂颈而还”；湿为阴邪，欲下泄而从小便出，

但又被热邪牵引而不能下行，故小便不利。热不得越，湿不得泄，互结蕴蒸，故身必发黄。治当清热利湿，方如茵陈蒿汤或茵陈五苓散等，均可酌情选用。

大陷胸汤由大黄、芒硝、甘遂三药组成，其主要功用已如前述。甘遂为泻水逐饮之峻药，尤善于泻胸腹之积水；大黄、芒硝泄热荡实，软坚破结。三药为泄热逐水之峻剂，可使大量水液从大便泻下。但因甘遂有毒，泻下峻猛，故应中病即止，不可过服。方后注云“得快利，止后服”，即是此意。由于甘遂的泻下有效成分难溶于水，故作汤剂水煎服时效力较差。本方虽用汤剂，但甘遂用末冲服，这一特定要求，发挥了甘遂的药效，应予注意。甘遂的用量，本书为一钱，因汉时有铢制而无钱制，应以赵本、医统本之“一钱匕”为准。今可酌用1克左右为宜。

伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石鞅者，大陷胸汤主之。（143）

【解析】本条承上文仍论大结胸的证治。

结胸证有三个主要症状，即本条所云：脉沉而紧，心下痛，按之石鞅，概括称之为“结胸三证”，犹如“麻黄八证”一样，是临床辨证要点。

伤寒时过六七日，虽未经误下，但治不及时，以致表邪内传入胸，形成“结胸热实”。“结胸”是言其病证，“热实”是言其病性，即热与水结，其病性属热、属实。验之脉诊，见沉而紧，沉脉候里且主水，紧脉为实又主痛，皆是热实结胸当见之脉。患者自觉心下疼痛，触按其病位，则有“石鞅”之感。石硬者，虽寓有夸张之意，但实指其上腹部腹肌紧张坚硬，其疼痛拒按自在言外。这一症状，常见于上腹部急性局限性腹膜炎的患者。以上的结胸主脉主证既具，则大陷胸汤势在必用。

通过学习本条“按之石鞅”一语，提醒医者临床凡诊治腹部疾患，包括现代医学所称急腹症在内，必须进行腹诊，亲手切按，以别病证。张仲景的《伤寒论》是比较重视腹诊的，如所云“绕脐痛”，“心下痞鞅”，“痛不可近”等，皆是由切按而得知。这是祖国医学传统的诊查病证的方法之一，应当注意继承运用，不可轻视忽略。

伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤。但结胸无大热者，此为水结在胸胁也，但头微汗出者，大陷胸汤主之。（144）

【解析】本条论述大柴胡汤证与大陷胸汤证的鉴别要点。

伤寒十余日不愈，表邪已化热入里，热结在里，必有大便不通等证，此为阳明胃家实之见证。但又见往来寒热之少阳证，则病属阳明热

结而兼病少阳不和，也即少阳阳明俱病。其治当用大柴胡汤泻下阳明、和解少阳而二经同治。

据理推测，上证既是阳明热结在里，可能见有心下痞满而痛；少阳受邪，枢机不利，可能见有胸胁苦满等证。因以上证候有类似结胸之处，故当认真加以鉴别。“但结胸无大热者”，是谓结胸因热与水结，水中有热，虽可有发热现象，但既不同少阳证的往来寒热，也没有阳明证的大热。大柴胡汤证是热与气结于胃肠，虽可有心下痞满而痛，但按之不硬；而结胸证则是热与水结于胸胁，故既有心下疼痛，又见按之石硬。因其热在水中而被郁遏，不能向外透越，故仅见头微汗出，而周身无汗，此亦是水热结胸的特征之一。论治无疑当用大陷胸汤泄热逐水破结。

总之，大柴胡汤证与大结胸证确有类似的临床表现，辨证时可从其热型、疼痛性质，以及腹诊等方面，进行鉴别比较。

太阳病，重发汗，而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹，硬满而痛，不可近者，大陷胸汤主之。

（145）

【解析】本条论述热实结胸兼阳明胃家实的证治。

太阳病重发汗，伤其津液，而复下之，邪热内陷入里。津伤胃燥，故五六日不大便，舌上燥而渴，又见日晡所小有潮热，此乃阳明胃家实之证。至于“从心下至少腹，硬满而痛，不可近”之证，一方面是言其病变范围广；另一方面是言其既有胀满疼痛的自觉症状，又有按之石硬的他觉见证；不可近者，谓其腹痛为甚，拒绝旁人近前触按，很类似现今所谓弥漫性腹膜炎的腹膜刺激征。这显系误下邪陷，邪热入里与胸腹间的痰水凝结而形成的大结胸证。因此本证属热实结胸兼阳明腑实。结胸与腑实孰轻孰重，孰急孰缓？当从证候分析：其腹痛范围从心下至少腹，较之阳明腑实的绕脐痛为广；其腹痛性质硬满而痛不可近，较之阳明痞满而痛的病情更重。再者，其热型是“小有潮热”，犹不及阳明的壮盛之势。由此可见，本证结胸重而急，腑实轻而缓。

《经方实验录》作者曹家达对仲景学说深有研究。是书载一案：某大结胸患者，自以为阳明证，服用大承气汤，药后大便泻下，胸腹稍畅。但次日证情如故，仍觉脘腹硬痛，又以为药不胜病，复进承气数剂，元气顿伤，反无效应。后经仔细一辨，证属结胸而兼阳明，改用大陷胸汤而愈。因承气汤仅能泻下阳明之燥热，而并无驱逐水邪之能，若用于大结胸兼阳明腑实证，虽肠胃之燥热可下，但胸腹间水热之邪难除，故非其治也。而用大陷胸汤既可攻水热之结，又兼下阳明之燥，一

举两得，施于本证，最为的当，更何况本证结胸证重而腑实证轻，因此大陷胸汤更是在所必用。

以上数条，都是论述大结胸的证治。所谓大结胸，是与下文的小结胸证相对而言的。临床辨大结胸，当抓住以下几个特征：一是其脉沉紧有力；二是其病证有硬满疼痛按之石硬之感，且病变范围可由胸至腹而比较广泛，程度严重，亦多兼有大便秘结。同时由于病位的不同，大结胸证又有病势偏于上、偏于中、偏于下的区别。如第139条的大陷胸丸证，“结胸者，项亦强”，是邪结在上之高位；第143条的结胸三证，“心下痛，按之石硬”，是邪结于中；本条结胸证兼阳明，“从心下至少腹，鞭满而痛，不可近”，病变之广已下及少腹。

昔日曾治一李姓女孩，15岁，患高热，周身不适与头痛等证，五六日后，突然发生胸腹疼痛，下午发烧更甚。经某医院诊断为急性腹膜炎，并令其住院治疗。其父因经济关系，乃转请中医诊治。诊其脉紧而搏，舌苔黄厚，大便从发病至今未解，小便红赤涩少，不欲饮食，时有谵语，皮肤亢热，腹肌板硬拒按。此外感邪热内陷，同水饮相搏，为大结胸证，脉证皆符，当急下之。乃疏大黄、芒硝各6克，冬瓜子、薏米各15克，甘遂末1克（另包）。先煎大黄等药，汤成，内入芒硝火上烱化，再下甘遂末和匀，分二次服。药后约一时许，即泻下，但不甚快，又将第二服分其半与之。服后不久，大便畅行，水与大便齐下，约半痰盂，患儿脘腹疼痛顿减，随之腹肌变软，热渐退，胃纳亦开，乃令糜粥自养而愈。

小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。
(146)

小陷胸汤方：

黄连一两 半夏半升，洗 栝蒌实大者一个

上三味，以水六升，先煮栝蒌取三升，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。

【解析】本条论述小结胸的证治。

小结胸的特点是病位“正在心下”，较大结胸之“从心下至少腹”为小，病位也局限，一般不向上下延展。证见“按之则痛”，远不及大结胸证的“鞭满而痛，不可近者”之重，且言外之意是如果不按则不痛。不过

在临床上也有不按亦痛的情况，只是痛势稍轻而已。其脉见浮滑，浮者为有热且浅，滑者是有痰且结，正是痰热相结而部位较浅的脉象反映，这和大结胸证因水热相结部位深广而出现的沉紧之脉自不相同。小结胸证，治用小陷胸汤清热化痰开结。

小陷胸汤亦由三味药组成，但药力比大陷胸汤为小、为缓。用黄连清泄心下之热结，则轻于大黄之泄热破结；用半夏化痰去饮，则缓于甘遂之涤痰逐水；用栝蒌实甘寒滑利，清热涤痰，开结润便，则逊于芒硝之咸寒软坚、泻实破结。此三药性缓而剂轻，远不如大陷胸汤之峻，故称为小陷胸汤。

方用“栝蒌实大者一个”，约合今之60克。当剪成条而先煮，然后再纳诸药入煎。因本证属痰热凝结，方用黄连以清之，半夏以散之，栝蒌以利之，故服汤后，热除痰去，多见大便排出黄色黏液，其病往往随之而愈。

栝蒌一药，不仅能清热涤痰，而且还有活血化瘀、通痹止痛的作用。《伤寒论》与《金匮要略》二书中所用栝蒌之方，都含有止痛之效应。除本方治心下按之则痛外，尚有栝蒌薤白半夏汤类诸方，主治胸痹疼痛，不用桃仁、红花活血化瘀，而仅用栝蒌等药便可止痛，可见其确有化瘀止痛之效。近年有用小陷胸汤治疗证属痰热凝结、脉络瘀滞的心血管病，每每可收到满意的疗效。然而今医之治，一见心胸疼痛疾患，开手便用红花、桃仁、丹参、赤芍之类，对栝蒌弃而不用，可算是临床一大损失，实不知仲景昔日用栝蒌治胸痹胜红花之奥义。有一经验方，主治乳痈而红肿热痛、寒热阵作者，即以栝蒌重用，疗效甚佳。方为：大栝蒌1枚，酒当归15克，萱草、甘草各10克，白芷6克，乳香、没药各3克，黄酒与水各半煎服。

小陷胸汤验案颇多，选录二例如下：

一老年妇人，五十余岁，正在心下胃脘部疼痛，且痛时有包块鼓起，形如馒头之半，心疑为癌患而甚畏惧，即往医院欲作钡透。在等待作钡透期间，因疼痛加剧不可忍耐，而请中医诊治。脉见弦滑，舌质偏红，苔黄不甚厚，胃脘虽痛但按之不硬，大便不爽，遂辨为小结胸证。服小陷胸汤二剂后，大便泻下黄涎甚多，痛止而包块消失。后做X线钡餐透视，查无异常。

某燕姓干部，昌黎县人，久患肺心病，心功能不全，每日靠强心药物维持，但仍喘促不得卧。综合其脉证，辨为痰热互结之小结胸证，遂试用本方。三剂后大便通畅，证情好转。

太阳病二三日，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有

寒分也。反下之，若利止，必作结胸；未止者，四日复下之，此作协热利也。（147）

【解析】本条论述素有水饮的太阳病，误下以后变成结胸或协热利的证候。

太阳病仅二三日，出现不能卧，但欲起的证候，可知其人“心下必结”。因心下邪气结滞者，往往卧则气痞益甚，而起立活动则稍有缓解。本病一是有太阳未解之表证；二是有邪结心下之里证。此时察之于脉，已由太阳表证本来的浮紧之脉而微微变弱，即“紧”象已减，显示寒邪有化热入里之趋势。其“心下必结”之里证，是因为“此本有寒分也”。寒分，指水饮之邪。可见其人既外有表邪欲化热，又内有水饮之宿疾。治当解表化饮为宜，而反误用泻下之法，则引邪入里，其病情发展可能有两种转归：或是邪结于上；或是邪注于下。若邪结于上，下利自止，太阳邪热因误下而内陷，与水饮凝结，故“必作结胸”；若邪热下注，则病至四日，仍见下利不止，这种协同表邪而下利的，则叫做“协热利”。

本条文义有二：一是说明有的结胸证的形成是“本有寒分”，即素有水饮，当误下之后，邪热与之相结，这与前述诸条结胸证的病因病机略有不同，可以互相补充。二是告诫医者，虽已有“心下必结”之见证，但表邪未解者，不可下之过早，早下可使邪热内陷而形成各种变证。

太阳病下之，其脉促，不结胸者，此为欲解也。脉浮者，必结胸也；脉紧者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉细数者，头痛未止；脉沉紧者，必欲呕；脉沉滑者，协热利；脉浮滑者，必下血。（148）

【解析】本条论述太阳病误下后，以脉测证的分析方法。

以脉测证与以脉定证不同。以脉测证，是根据脉象推测证候，如本条内容即是。以脉定证，是在具备一定症状的前提下，最后通过脉诊，以决定其属于何种病证。如已有发热、汗出、恶风等证，再切其脉若见浮缓，便可断为太阳中风的桂枝汤证。不但如此，临床辨证中，还有舍证以从脉的情况，这更体现了脉诊的重要性。

本条文众释纷纭，颇难理解，若照原文解析，不仅义不连贯，则多有牵强之处。《医宗金鉴》认为原条文有错简而稍作修改，似乎比其他的注释较合情理，故从其说而作注解。原文的“其脉促”可改为“其脉浮”；“脉浮者”改为“脉促”；“脉紧者”则改为“脉细数”；“脉细数者”可改为“脉紧”；“脉浮滑者”则改为“脉滑数”。

太阳表证误下之后，可设想有以下诸般变证：若其脉浮，是邪仍在表而未入里，故不作结胸，因表邪已微，病有欲解之势，所以说“此为

欲解也”；若脉促者，是为阳热过盛，邪欲入里而有结滞之象，故“必结胸也”；若脉见细数，是阴伤而有虚热，故“必咽痛”；脉弦，为少阳之脉，少阳经气不和，所以见“两胁拘急”；紧脉主寒，脉紧说明太阳表寒未解，故原有的头痛未能得止；沉脉主里，脉沉紧，说明里有寒，胃气受寒而上逆，故“必欲呕”；沉脉候里，滑脉主热，脉沉滑反映表邪误下内陷而化热，热迫大肠，故作“协热利”；脉滑数，亦为里有邪热，热伤阴络，故大便下血。

本条文只求理解其主要精神，临床辨证时切不可拘泥搬套。凭脉辨证，固然是一个重要环节，但更为重要的还是应脉证合参，全面分析。

病在阳，应以汗解之，反以冷水澀之，若灌之，其热被却不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散。若不差者，与五苓散。寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤，白散亦可服。（149）

文蛤散方：

文蛤^{五两}

上一味为散，以沸汤和一钱匕服，汤用五合。

白散方：

桔梗^{三分} 巴豆^{一分}，去皮心，熬黑，研如脂 贝母^{三分}

上三味为末，内巴豆，更于臼中杵之，以白饮和服。强人半钱，羸者减之。病在膈上必吐，在膈下必利，不利进热粥一杯，利过不止，进冷粥一杯。身热，皮粟不解，欲引衣自复者，若水以澀之、洗之，益令热却不得出，当汗而不汗，则烦。假令汗出已，腹中痛，与芍药三两如上法。

【解析】本条通过水结于表，与水结于里的结胸证相对比，寒实结胸与热实结胸相对比，以体现水结有表、里、寒、热不同的证型。

原文的“小陷胸汤”和“亦可服”；白散方下的方后注文“身热，皮粟不解”以次的文字，均属衍文，当删。本条重点介绍文蛤散和三物白散两个方证，下面分作两段解析，先讲文蛤散证：“病在阳”，即病在表，当用汗法解表，而“反以冷水澀之，若灌之”，澀，为以冷水喷淋；灌，为以冷水浇浴，皆是古代物理降温退热之法。然施于太阳表证，则为治不顺理。其结果是身热可能暂时稍退，但阳郁之热不能宣散，故“弥更益烦”。弥、更、益三字皆是“更加”之意。烦者，热也，即发热反比以前更重。由于阳热被冷水闭郁，皮毛腠理收敛，寒凝于外，热郁于内，故肌肤上起如粟粒状的“鸡皮疙瘩”。同时可有发热、无汗、身体酸痛等见证。因寒凝热闭，太阳的体表津液得不到宣通，则热与水结于太阳之表，因尚未入里，故虽口渴但又不愿喝水。治用文蛤散，既可清在表的阳郁之热，又能行皮下之水结。若服药后病不愈，而又见烦渴、小便不利等蓄水证，则当用五苓散解表以利水。

对于文蛤散，一部分注家认为即是原文所载之方，而柯韵伯等人则认为是《金匱要略》文蛤汤（即麻黄杏仁甘草石膏汤加文蛤、生姜、大枣）之误。鉴于本条属一证二方之法，犹如前述之先用小建中汤，后用

小柴胡汤之例，因证有一轻一重，方亦有一大一小，故本证之治仍以一味文蛤散为宜。

文蛤即海蛤之有纹理者，其性咸寒，上能清肺化痰而治咳逆上气，下能利小便而治水气浮肿。本证为水热之邪闭郁体表，故用之既清在表之热，又行皮下之水。

下边再论寒实结胸的证治：

“寒实”，是指水寒气冷所凝结的痰饮之邪的实证，这种寒性痰饮内结于心胸，心胸阳气受阻，则可出现硬满而痛，甚或见气喘咳逆等证，故谓之“寒实结胸”。因其无发热、烦渴、苔黄燥等热证，故与热实结胸证不同。但寒实结胸属于实证，所以脉沉紧有力，且有大便不通等一派实证的表现。治用三物白散散寒逐饮，除痰开结，以温下寒实之邪。

白散由桔梗、巴豆、贝母三药组成，因其药色白，故又称“三物白散”。巴豆辛热有毒，能攻逐寒性水饮痰湿之凝结，其力十分峻猛，故一定要经炮制后方可入药；贝母消痰开结；桔梗开提肺气，既可开肺散结祛痰，又可使药力作用于上。三药并用，可将寒饮痰水一举排出，故服本方后，可见或吐或下，或吐下交作的反应。因本方药性峻猛，故用白饮和服，既能和养胃气，又可稍制巴豆之毒性。本方属温下寒实之剂，故欲加强其泻下作用，可进热粥以助药力；如腹泻太甚，又可进冷粥以抑制其泻下作用，用粥也取其有保胃气作用。所用剂量“强人半钱”，应依赵本、医统本改为“半钱匕”为是。体质壮实者，今可服至1克左右，对体质弱者，则当酌减其量，以免泻下伤正。

太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎第一间，肺俞、肝俞，慎不可发汗，发汗则谵语。脉弦，五六日，谵语不止，当刺期门。（150）

【解析】本条论述太少并病类似结胸的证治。

先病太阳，后病少阳，太少俱病而有先后次第之分，谓之太少并病。头项强痛，是属太阳表证；头目眩冒则为少阳病变。少阳之气疏泄不利，故心下痞塞硬满，有时郁结较甚者，还可发生疼痛，则犹如结胸之状。证属太少并病，当刺大椎、肺俞两穴以解太阳之邪；刺肝俞以解少阳之邪。切勿仅以头项强痛而用发汗之法，因少阳有禁汗之制，若误汗，则既伤胃中津液，又使少阳之邪热乘于胃。胃燥不和，故发生谵语。“脉弦”，为少阳之脉，病经五六日，又见谵语者，是见阳明证候。但因脉弦反映少阳之邪仍未解，故虽有阳明里证，亦不可下，因少阳也有禁下之制。所以治用刺期门之法，以泻肝胆之热，俾少阳热除，则胃

热多能透达，而谵语自止，此亦为治病求本之法。

妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而泻之。（151）

【解析】本条论述妇人经水适来而热入血室如结胸状的证治。

“得之七八日”一句，移至“经水适来”之前较为合适。妇人中风，发热恶寒，时至七八日，经水适来，或按期或不按期而至，此时血室空虚，表邪常可乘虚而入。邪内入则表证解，故热退身凉而脉迟。脉迟，说明气血涩滞，邪有所结。又见胸胁下满甚或疼痛，犹如结胸状，并作谵语，此即为热入血室之证。关于血室的实质，历来争议颇多，当以“胞宫”之说为妥。因胞宫与肝经密切联系，胞宫受邪热所侵，必影响肝胆之气疏泄不利，故胸胁下满如结胸状，这是血病及气的表现。诸血者皆属于心，血分有热，血热上扰心神，故见谵语。此处谵语与阳明燥热证之谵语病机不同。因肝藏血而主疏泄，与胞宫有内在的联系，故通过针刺以泻肝胆邪热，则胞宫血分之热即可解围，因此，采用针刺肝之募穴期门的方法，其病则愈。

妇人中风，七八日，续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。（152）

【解析】本条论述妇人经水适断而热入血室寒热如疟的证治。

“经水适断者”，移至“续得寒热，发作有时”之前较为合适。“妇人中风”，言病由外感而来，时至七八日，经水适断，即月经不当断而断，此为热入血室、热与血结所致。血室血结，进而影响肝胆之气不利，少阳之气不和，故又续发寒热休作有时，犹如疟状。文中“此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时”一段，正是对本证病因、病机及证候的自注说明。根据《医宗金鉴》和一些注家意见，考虑到本证有经水适断，其血必结的病变特点，在治疗时应在小柴胡汤和解少阳、疏达气机的基础上酌加丹皮、生地、红花、桃仁等活血凉血之药，验之临床也确比单用小柴胡汤疗效为好，故录之于此，以资临证参考。

妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。无犯胃气及上二焦，必自愈。（153）

【解析】本条论述妇人经水适来而热入血室的自愈证。

妇人患伤寒发热，正值经水适来，证见昼日神识清楚，入夜则神识

昏愤而谵语，此亦为热入血室证。因人之阳气昼行于阳，夜行于阴，而本证是血分有热，血亦属阴，故入夜阴分阳热炽盛，而见谵语等证。“无犯胃气及上二焦”，讲的是治疗法则。张仲景在这里告诫医者，不要以其有谵语而就判属阳明，以致误用泻下之法而伤害胃气。因本证之谵语并非阳明气分有热，而是由于血室有热。在治疗上不必刺期门或者服小柴胡汤，因其经水适来而血不断，邪热有随血而去的机转，故云“必自愈”。此证不同于经水适断的热入血室证，故有自解之机。

以上三条，均论热入血室证，皆属妇人之病。有人提出“阳明病篇”也有热入血室证而未明言妇人，故认为男子也有此证。这种说法我们认为欠妥。因血室即指胞宫，唯妇人生理所独有。而本病的形成，也正是这种生理特点所决定的。临床上不仅见于月经期，而且也可见于产后。因仲景在“太阳病篇”的三条热入血室证中已明言妇人之病，故在“阳明病篇”的热入血室证中就略而不提了。

在结胸证和太少并病之后，论述热入血室的证治，这是因为既有如结胸状，又和少阳证有关。结胸是言水结，少阳是言气郁，热入血室是论血病。作者把水、气、血三种有类似证候的病证，巧妙地贯串在一起而论，并在辨证论治中相互对比发明，其目的是为了扩大读者的辨证视野和提高辨证能力。

伤寒六七日，发热微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。（154）

柴胡桂枝汤方：

桂枝去皮 黄芩 人参各一两半 甘草一两，炙 半夏二合半 芍药一两半 大枣六枚，擘 生姜一两半，切 柴胡四两

上九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服。

【解析】本条论述太少并病的证治。

伤寒六七日，证见发热微恶寒，肢节烦疼，并且疼痛的很厉害，这属于太阳表证不解。此外又见微呕、心下支结等证，则属于少阳的半表半里证。先病太阳，其邪未解，又病少阳，太少先后发病，故属于太少并病的范围。至于“心下支结”一证，则有两种解释：其一支者，撑也，指心下支撑痞满；其二支者，边也，指其痞结在心下两边的部位，即肋肋少阳部位。二说均有道理，也符合临床实际。前言少阳病喜呕，此是

微呕；前言胸胁苦满，此言心下支结。虽都是少阳之气不和所致，但相较之下可知本证的少阳病势较为轻浅。可见此证虽属太阳、少阳并病，但以太阳证为重，少阳证为轻，故用柴胡桂枝汤双解两经之邪。

柴胡桂枝汤，即小柴胡汤与桂枝汤剂量各半的合方，桂枝汤外解太阳之邪，以治发热微恶寒、肢节烦疼；小柴胡汤内和少阳枢机，以治微呕、心下支结。此发表与和里兼用之法，乃为少阳权变治法之一。

因本方既能调和营卫气血，又能和解表里，疏利肝胆，故临床治疗范围颇广，应用机会亦甚多。本方去大枣，酌加鳖甲、牡蛎、红花、茜草等软坚化瘀药，常用于治疗慢性肝炎、肝脾肿大以及早期肝硬化等病证，并多能取效，但并非十数剂所能已，因其药性平和，故可久服无妨。本方还可治疗“肝气窜”的病证，此证多见于妇女，患者自觉有一股气在胸胁脘腹甚至四肢游走窜行，气至之处则觉疼痛，医生检查多无器质性病变，辨证多属肝气郁结，气血不和，故俗名“肝气窜”，本方舒肝调气兼和血脉，用之每可获效。对于风湿痹证而兼胸胁苦满、脉弦等肝气不舒证者，应用本方而效亦满意。

伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。（155）

柴胡桂枝干姜汤方：

柴胡半斤 桂枝三两，去皮 干姜三两 栝蒌根四两 黄芩三两 牡蛎三两，熬 甘草二两，炙

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，取三升，温服一升，日三服。初服微烦，复服汗出，便愈。

【解析】本条论述伤寒误治而致邪传少阳，气化失常，津液不布的证治。

伤寒五六日，汗而复下，是为误治。太阳之邪传入少阳，故胸胁满闷。“微结”，是指少阳气机有所郁结，但势微而不甚重。由于误下之后，挫伤气机，致使气化不利，三焦水道不畅，则见小便不利；气不化津，津不上承，则见口渴；阳郁不宣，上蒸于头，则见头汗出而身无汗；邪热进退于少阳之野，故往来寒热而心烦。邪气在三焦而不及于胃，所以不呕。本证重点在于少阳气机不和、气化失常、津液不布，所

见小便不利，汗出不畅，颇像湿热之证，但口渴不呕，则知并非湿热。治疗用柴胡桂枝干姜汤，一则和解少阳枢机之邪；二则助气化以生津液。

柴胡桂枝干姜汤由小柴胡汤加减化裁而成。柴胡、黄芩作为主药，仍用于清解少阳半表半里之邪；因津伤口渴而不呕，故去半夏加栝蒌根，生津胜热以止烦渴；阳郁气滞，枢机不利，胸胁满微结，故去人参、大枣，加牡蛎软坚散结；桂枝配干姜，通阳化阴以行三焦。诸药相伍，可使少阳得和，枢机畅利，气化以行，阳生津复，诸证悉愈。方后注云“初服微烦，复服汗出”，这是药后阳达津布之象，为正复邪却的反映。

根据本方的药理作用和临床实践，用之治疗少阳病而兼太阴脾家虚寒的证候，确为对证之方。与大柴胡汤治疗少阳病而兼阳明胃家热实的证候相对比，恰有寒热虚实对照鉴别的意义。少阳不但为表里之枢，也为阴阳之枢，故邻近于太阴。当少阳病内及太阴之时，则可见脘腹胀满、便溏不调、脉缓无力等证。在临床上某些慢性肝病的患者，常可见到这类证候，它既有口苦、口渴、心烦、胁痛等肝胆热郁之证，又有便溏、腹胀、纳差等脾胃虚寒之象。由于本方寒热并用，肝脾同治，既清肝胆之热，又温脾胃之寒，故用于治疗这类寒热错杂的肝脾疾患，疗效卓著。据临床观察，有些慢性或迁延性肝炎患者，右胁放射疼痛上达肩胛，下至腰部，或见右臂与手指麻木，下午腹胀，脉弦而缓，用本方每可收效。此外，对于寒多热少之疟疾，以及口渴欲饮的糖尿病等，若见有少阳主证者，用之得当，亦可收效。

伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结，必有表复有里也。脉沉，亦在里也。汗出为阳微，假令纯阴结，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也。可与小柴胡汤。设不了了者，得屎而解。（156）

【解析】本条通过阳微结与纯阴结的脉证鉴别，说明少阳病气郁之时与少阴病有类似之处，并指出了其治法。

全条分三段，第一段从“伤寒五六日”至“必有表复有里也”，论阳微结的脉证。第二段，从“脉沉，亦在里也”至“故知非少阴也”，论阳微结与纯阴结的鉴别。第三段，从“可与小柴胡汤”至“得屎而解”，指出阳微结的治法。

病起自伤寒，其表未解，故微恶寒；又有心下满，口不欲食，大便硬等证，则为阳明里热已结，同时又见手足冷、头汗出，则是因表里之

气不利，阳热郁结而不能宣达所致。阳不达四末，故手足冷；热不得外越，故仅头汗出而周身无汗。此时如果又见细脉，即弦细之脉，弦为少阳之主脉，则反映少阳气郁而枢机不利，可见本证既有太阳表邪不解，又有阳明热结于里，还有少阳表里之枢机不利，这种“必有表复有里”的见证，古人称为“阳微结”。所谓“阳微结”，也即阳热内结尚属轻浅，而外邪犹未悉入其里之意。此即第一段的内容。

第二段采用推理辨证的方法，对阳微结与纯阴结作了鉴别比较，因为阳微结的某些表现有与纯阴结类似之处，故不可不辨。如说其人脉沉，沉以候里，里为阴，而病属于纯阴结（即少阴病）的话，那么对头汗出也可理解为阳气虚微所致，但是纯阴结本属里虚寒之证，邪离三阳，其证为阴，则当无发热、恶寒等外证，而只能见到一派少阴阳虚的里寒证，故云“不得复有外证”而“悉入在里”。阳微结若与纯阴结对比，则前者为“半在里，半在外也”，即外有太阳表证，内有阳明热证。此时即使是脉见沉紧，也不能称之少阴病，所以然者，是因为阴证不得有汗，而少阴若见汗出，则多是亡阳之象。头为诸阳之会，只有阳经上行于头，而阴经不能上行头部，故今见头汗出，知是阳热内郁而不得外泄，上蒸于头所致汗出，由此可知其证并非少阴病，实为阳微结的见证。

阳微结证，虽半在表半在里，但病之关键，在于少阳枢机的郁结，故治用小柴胡汤和解少阳，疏达枢机。枢机通利，表里则和，其病可愈。若服汤后“不了了者”，即仍有不爽快的感觉，是谓里气不和，亦可有心烦等里热见证，此因肠胃尚有热结，大便硬而不下之故，可考虑使用小剂调胃承气汤微和胃气，使大便得下则愈，故云“得屎而解”，这是第三段内容。

阳微结与纯阴结，皆为古之证候名称。前者属腑病，后者为脏病，细察脉证，辨别不难。然而通过两者的鉴别，说明阳热郁结有时可出现类似阴寒的见证，也即所谓“阳证似阴”。特别是临床常能见到的阳郁而致手足厥冷，如四逆散证，若不综合全局，详审病机、反复推敲，仅凭一证之见，武断为阳虚的纯阴结而妄投温补，必将如抱薪救火，后患无穷。

伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而鞭痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之；但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。（157）

半夏泻心汤方：

半夏半升，洗 黄芩 干姜 人参已上各三两 黄连一两 大枣十二枚，
擘 甘草三两，炙

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煮取三升，温服一升，日三服。

【解析】本条论述误下少阳之后，所出现的三种不同情况的证治。

伤寒五六日，出现呕而发热的少阳证，医者不用小柴胡汤和解，反以他药泻下，此犯少阳之禁，实属误治。若其人正气旺盛，证情不因误下而发生变化，柴胡证仍在者，可复与小柴胡汤。此虽经误下而病未逆变，故云“不为逆”。但正气毕竟有所耗伤，难于胜邪，服汤后因得药力相助，正复而驱邪，故发生“战汗”作解的现象。这是一种情况。

若误下后，其人证见心下满痛，按之石硬，是为结胸证。此因少阳邪热内陷入里与水饮互结而致。与前言误下太阳而成结胸，起因虽有所不同，但见证并无差异，故仍当用大陷胸汤泄热逐水破结。这是第二种情况。

第三种情况即误下后，其人证见心下满而不痛，是为痞证。痞之成因，是误下少阳之后，脾胃之气受伤所致。因脾主升、胃主降，脾胃受伤则升降失常，气机受阻不利，故发生心下痞塞不通之感。再者，本病来自于误下少阳，少阳喜呕，多是胃有痰饮而气逆，故本证亦多是气机痞塞而夹痰，故又称之为“痰气痞”。然痞之病位，又为何恰在心下？先从体表部位看，胸为阳，腹为阴，“心下”，位于胸腹之夹界，此亦为阴阳部位上下交通之处。前言少阳胁下为半表半里，是从纵向看，此言心下为半上半下，是从横向分。总之二者皆为阴阳枢纽之地。再从内在脏腑看，脾胃皆居心下，脾脏属阴，胃腑属阳，脾胃升降失常，气机痞塞，阴阳不和，寒热错杂，故其病变亦多在心下部位。痞之表现，既非胸闷，也非腹胀，而是自觉仅在心下有痞满堵塞之感，但按之濡软，因其并无有形之邪滞结，只不过气机痞塞之故。气机痞塞于中，胃气不降而上逆，则每见呕吐、噎气、恶心等证；脾气不升而下陷，则每多见下利、肠鸣或大便干湿不调等证，心下痞满证属上下的枢机不利，与少阳病半表半里枢机不利的胸胁苦满，病证不同，病位不同，病机也不同。故不能刻舟求剑再予小柴胡汤，所以说“柴胡不中与之”。心下痞证虽心下痞满，但按之不硬不痛，这又区别于结胸证的心下痛，按之石硬，故更不可与陷胸汤。治疗之法，只宜选用半夏泻心汤和中降逆消痞气。

半夏泻心汤与后面要介绍的生姜泻心汤、甘草泻心汤，均可谓是小柴胡汤的变方，属和解之法而主治心下痞。但三方之中，又以本方为代表方。因本证以呕吐、心下痞、大便不调为特点，而《神农本草经》言半夏“主伤寒寒热，心下坚下气……胸胀，咳逆肠鸣”，既能化痰降逆，又能消痞散结，故本方以半夏为君，而定名为半夏泻心汤。本方由七味药组成，实系小柴胡汤去柴胡，加黄连，以干姜易生姜而成。方中半夏、干姜辛开而温，以散脾气之寒；黄芩、黄连苦泄而寒，以降胃气之热；人参、甘草、大枣甘温调补，和脾胃，补中气，以复中焦升降功能，此即所谓“辛开苦降甘调”之法。总之，本方寒温并用、苦辛相投、攻补同施，具有和阴阳、顺升降、调虚实之功，故为和解治痞之良方。

本方治痞，早已公认无疑。但古人认为本方证属痰气痞，其内是否有痰，昔常疑之，不甚信服。后经治某司机，因其素嗜饮酒，患心下痞，并见时时恶心呕吐、大便不调、脉弦滑、舌苔白等证，遂辨为酒湿生痰，痰浊成痞。服本方一剂后，大便泻下白色黏液甚多，心下痞塞之证即十去其七，凡四剂而痊愈。由此方信痞证多夹痰，痰去痞则消之说。

张仲景所立以半夏泻心汤为首的诸泻心汤方，实为内科治疗胃病开辟了法门。临床所见单纯胃寒或胃热证，均不难治，若遇寒热错杂证则较棘手，但善用诸泻心汤者，则有方可施，随手拈来。现代医学所谓慢性胃炎、胃肠炎、溃疡病，以致肝、胆病等疾患，常可出现这类证候，运用此法，化裁得当，多能收效。

太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下鞭，下利不止，水浆不下，其人心烦。（158）

【解析】本条论述太阳少阳并病误下而致结胸，证似太阴的危候。

太阳病宜发汗，少阳病宜和解，泻下之法均属禁忌。太阳少阳并病，本当用柴胡桂枝汤双解两经之邪，舍此反用泻下之法，是属误治。以致使太阳少阳邪热内陷，热与水结而成结胸，故见心下硬。结胸证因水热互结、气机不畅，多影响腑气不利而见大便秘结。今不仅不见大便秘结，反见下利不止，水浆不入，此为结胸证似太阴，是属误下而致脾胃虚寒、中气下陷之危候。结胸为邪实，脾胃虚寒为正虚，正虚邪实，正不胜邪，故其人心烦。

对本条的解释，成无己有其独特见解，认为太少并病而误下，其变证当分二端：一是太阳表邪入里，结于胸中为结胸，心下硬；二是少阳里邪，乘虚下于肠胃，遂利不止，这种分两证的说法可资参考。

至于本证的治疗，历代医家众说纷纭，有说可治者，亦有说不可治

者，但不管是持何种意见的医家，一致认为本证病情是危重的。因其正气大虚，故陷胸汤，即使是小陷胸汤亦不可用。按照辨证论治的原则，或投以理中汤类温补，或试用柴胡桂枝干姜汤，或可望取效。总之当以调补脾胃而扶正气为要，这是治疗本证的基本出发点。

脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞。按之自濡，但气痞耳。（159）

【解析】本条论述伤寒表实误下成痞的辨证。

脉浮而紧，为伤寒表实证之脉，在此代表伤寒表实证。应以麻黄汤发汗解表，若误以下法治疗，则“紧反入里”。这里的“紧”是代表寒邪，非为紧脉。误下里虚，脾胃气伤，无形之邪内陷，结于心下，致使中焦升降失常，气机痞塞，故作心下痞。结胸证是邪热与有形之痰水相结，故心下硬满而痛，按之石硬；痞证是无形之气痞塞，故心下痞满不痛，按之自濡，此即所谓“但气痞耳”。

临床所见，偶有痞证患者，心下部位鼓起包块，犹如鸡卵或大如拳头，或可自行移动，或可自起自散，乍一看似肿瘤，病家也多为之惶恐不安。但以手按压，则觉濡软而即陷下，松手又随即复起，这可以说是气痞的特征。通过腹诊，则比较容易与结胸证相鉴别。又心下痞证一般多不疼痛，仲景亦云：“但满而不痛”，但临床实践证明，痞证也确有疼痛者，不过较之结胸则为轻为缓，且多不拒按，此亦不可不知。

太阳中风，下利，呕逆，表解者，乃可攻之。其人^{热热}汗出，发作有时，头痛，心下痞，鞭满，引胁下痛，干呕，短气，汗出，不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。（160）

十枣汤方：

芫花熬 甘遂 大戟 大枣十枚，擘

上三味等分，各别捣为散。以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药末。强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平旦服。若下少病不除者，明日更服，加半钱，得快下利后，糜粥自养。

【解析】本条论述结胸类证——胁下悬饮的证治。

在太阳中风的病程中，可续发水邪的凝结而成悬饮证。其病位，即水之巢穴虽在于胁下，但其影响所及，却是表里内外、三焦上下无所不

有。故水饮注于下则见下利。水饮逆于上，则见呕逆。由于水饮之巢穴深居于胸腹之间，两胁之下，非一般渗利之药所能取效，故当用攻逐泻水之剂。但应注意在表邪尽解后方可议攻，避免因攻伐水邪损伤正气，而招致表邪的内陷。故仲景告诫曰：“表解者，乃可攻之”。

由于水饮之邪变动不居，故或见之证颇多。如“**𦵿𦵿**汗出，发作有时”，为水邪外走肌腠皮肤，影响营卫失和所致；“头痛”，为水气上逆，冒蔽清阳所致。此汗出、头痛，类似太阳中风证，故也有的注家将本证划归太阳病类证。然本证微微汗出，却发作有时，头虽痛而不恶寒，故又与太阳中风证不同。“心下痞，鞭满”，为水结胁下，影响中焦气机不利所致，类似结胸，但并非结胸；“引胁下痛”，则为本病之主证，不仅指心下痞硬满牵引胁下疼痛，而且包括转侧身动，甚或咳嗽、呼吸、说话等，都可引起胁下作痛。此乃因水之巢位在于胁下，使局部气血壅滞、筋脉不和所致；“干呕”，为水饮犯胃，胃气上逆；“短气”，为水饮迫肺，肺气不利。真可谓是水势泛滥，浩浩莫御。若当其时而见汗出不恶寒，是为表邪已解，仅是里有水饮，故云“表解而里未和”，可予十枣汤攻之。

《金匱要略·痰饮咳嗽病脉证并治》把本证称为“悬饮”，列为四饮之一，论述较详，若能结合学习体会，则可加深理解。临床辨识本病，当须掌握以下几个主证：胁下疼痛，心下坚满，咳逆短气而呕，颜面可见黧黑或发青。治疗应当抓住病之根本，攻逐胁下水之巢穴，不要光看到水邪影响所及的各种表现，而去一一对证施治。同时，此种水证，非一般利小便之法，如五苓散辈所能及。因其有形之水饮已聚结胁下，筑巢而居，若非峻剂，则不足以疏决外出。

《嘉定县志》载一医案，可谓是生动实例。太仓之地某武姓之妻，证见起立如常，卧则气绝欲死，求医无效。时有名医唐得明，诊之为“悬饮”，辨证云：“饮在喉间，坐之则坠，故无害。卧则壅塞诸窍，不得出入而欲死也”。投以十枣汤而平。

十枣汤为峻下逐水之剂，芫花、甘遂、大戟皆是苦寒泻水有毒之药，三者合用，可谓集泻下逐水药之大成，其性峻烈迅猛，可直达胁下水巢，一鼓而破之，使水饮之邪溃泻而下。然而本方却不以甘遂等三药为名，反名为“十枣汤”者，意在告诫人们：祛邪勿忘扶正，保胃气、存津液，犹当牢记。因胁下之水非攻不可，故必用逐水峻药；而正气之伤也不可不顾，故扶正之品也在所必用，方能达到祛邪不伤正、扶正不留邪的目的。既欲扶正，何不用参、芪之辈？因虑其甘温补气，而碍于攻下。甘草性味虽然甘平，但又与诸逐水药相反，不可为伍。最为相宜

者，则莫过于大枣。《神农本草经》谓：“大枣味甘平，主心腹邪气，安中养脾……补少气，少津液……和百药”。可见大枣既可补养脾胃，益气生津，又能缓和药性，以制诸药之毒。原方大枣用10枚，要求选用肥大者，若是瘦小者，当用至20枚或30枚，煮成浓汤，再纳三药之末1克至2克，清晨空腹服下。因药末对口腔黏膜有较强的刺激作用，使人难以耐受，故切勿将其直接投入口中。今也有人将药末装入胶丸中而用枣汤送服，此法亦可。若服后泻下量少，病则不除，可酌情加量再服。得畅快之利后，则以糜粥自养，调理善后而安。

现时常有报道，用本方治疗渗出性胸膜炎、胸腔积液、腹水等病证，效果比较满意。但本方毕竟药性峻烈，使用时必须慎重。

太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤_𦞙者，难治；今色微黄，手足温者，易愈。（161）

【解析】本条论误治的坏病以及对坏病预后的判断。

太阳病治用汗法是正确的，但发汗有轻重缓峻之分，只有运用得当，才能中病有效。今发汗之后病未愈，发热恶寒反更重，说明发汗不得其法。然一汗不解，本可再汗，但医者辨证不清，又改用了下法，而造成一误再误。发汗不当伤其表，误用下法又伤其里，致使“表里俱虚”，而“阴阳气并竭”。阴者，里也；阳者，表也；竭，乃正气竭乏，即表里气血俱虚之义。若脾胃之气受伤，而邪气乘虚内陷，致使气机痞塞、升降紊乱，则可形成心下痞证。“无阳”二字，在本论不止见于一处，成无己解释为“表证罢为无阳”，“阳”，非指阳气而言，而是当作表证讲，若与第28条的“脉微弱者，此无阳也”之文互参，其义自明。因此“无阳则阴独”，是说无表证而只有里证，即表证已解，只存在心下痞的里证。在这种情况下，本应选用泻心汤类方剂和胃消痞、益气补虚，但医者却用“烧针”的方法进行治疗，实属大谬。烧针本为治疗寒痹的疗法，若用之以劫汗而治痞，则反而变成致病因素的火邪。火气通于心，心居胸中为阳位，火邪扰于心胸，必见心胸发烦之证。

此证由于多次误治，病情不断演变，不仅邪气未去，而且正气也大伤，此时细心观察病情，对预后作出判断，则有重要临床意义。气色是脏腑气血荣枯状况的反映，青为肝之色，黄为脾之色，面色青黄不华，为肝气刑脾，木来克土之象。肤之外者为皮，由肺所主；肤之内者为肉，由脾所主。肤_𦞙动者，为脾肺之气两虚，皮肉之气不充所致，由此可以推知，其人的手足也必然发凉。见“面色青黄，肤_𦞙者”，脏气已大伤，故多“难治”，而预后较差。假令面色微黄，黄为脾之正色，微黄标

志着胃气尚存。脾胃主四肢，手足温暖不凉，说明脾胃阳气不衰。胃气犹存而化源不绝，则能与邪相争，此虽是误治的坏病，但还是容易治愈的。

由此可见，对心下痞之证，还应注意面色的变化及手足温凉等情况，借以了解正气的强弱和阳气的盛衰。伤寒病的预后，多以阳气的盛衰为左右，因此对反映阳气情况的证候更应详察。

有很多注家认为本条难以解释，因而每每避而不释，有的注家虽作了解释，但也不够清晰，唯有成无己的注解还比较通顺，可资参考。

心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。（162）

大黄黄连泻心汤方：

大黄二两 黄连一两

上二味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。

【解析】本条论述火痞的脉证与治法。

条文言简而意赅，只提一证一脉便予处方用药，这就是《伤寒论》善抓主证的具体体现。

一证就是“心下痞”，即胃脘部堵塞不通之感。“心下痞”作为一个症状，可以由很多原因引起，如水热互结，气机壅遏的结胸证；胃肠燥热，腑气不畅的腑实证等，这就需要借助其他诊察方法以作鉴别，其中的腹诊便是一个重要的方法。“按之自濡”，濡通软，即心下虽痞，但按之柔软，说明此证并无实邪结聚，正如第159条所说：“按之自濡，但气痞耳”，只不过是气机不畅、痞塞于心下罢了。这样可与心下痛按之石硬的结胸证、脐腹按之有“燥屎五六枚”的阳明燥实证相鉴别，以加强辨证能力。

一脉就是“关上浮”。关脉居尺寸之中，主中焦病，用以候脾胃。“浮”，在此泛指阳脉，如浮、大、数、动、滑等脉皆属此例。关上见阳脉，反映中州有火热之邪，火热邪气结于心下，因而成痞，这又与结胸及阳明腑实证之寸浮关沉或沉紧之脉大不相同。本条虽仅提出一脉一证，但若把脉证互相联系起来分析，就不难看出，此证属火热邪气痞结于心下，使胃气不和而作痞证，故又有“火痞”或“火气痞”之称。治以大黄黄连泻心汤泄热而消痞气。

本条仅用20余字，便把火痞的病机、病位、病性、主要脉证、治则与方药概括无遗。然在临床辨证时，据此尚嫌不够全面，往往还需要参考一些其他症状，如火热邪气上扰，多见心烦，甚或吐血衄血；火热邪气迫于小肠则见小便黄赤；火热痞塞于心下，影响胃肠之气不利，可见大便虽通但不爽。此外舌质红绛、苔薄黄等也多可见到。若能综合多方面的火邪表现，结合本条主脉主证，则可准确无误地作出诊断。

大黄黄连泻心汤由大黄、黄连组成。方中大黄苦寒，本为推陈致新，清热通便，荡涤肠胃之药；黄连苦寒可清心胃之热而能厚肠胃。本证既为无形之热邪痞结心下，并无有形之实邪结滞肠道，而为何反用大黄之下？妙在本方的煎服法与众不同。方后注云：“右二味，以麻沸汤”渍之，“须臾绞去滓”，是说二药并不煎煮，而是用滚开的热水浸泡片刻，然后即去滓饮汤。如此渍药之义，则取二药苦寒之气以清中焦无形之邪热，薄其苦泄之味而防止其直下肠胃。《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治》中，用本方加黄芩，名泻心汤，治吐血、衄血，但用煎煮之法，而且顿服，则取其味厚力大而泻其血分之热。用药虽一，服法有别，效应各异，可谓法中之法。

《千金翼方》注云：“此方本有黄芩”，下条附子泻心汤中亦有黄芩，故宋臣林亿等认为本方中应有黄芩。若有黄芩，则泄热消痞之力更强。

唐容川在《血证论》中第一张治血病的方子即泻心汤，用其清血中火热而止血。临床经验证明，用之治吐血、衄血、心下痞而烦、牙痛等诸般火热邪气所引起的病证，效果均非常理想。然在使用时，大便不秘结者，可用开水浸泡法服药；对伴有大便燥结者，亦可采用煎煮之法。

心下痞，而复恶寒，汗出者，附子泻心汤主之。（163）

附子泻心汤方：

大黄二两 黄连 黄芩各一两 附子一枚，炮，去皮，破，别煮取汁

上四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾，绞去滓，内附子汁，分温再服。

【解析】本条承上条论述热痞兼表阳虚的证治。

这里的“心下痞”即指上文的“热痞”。本为热痞，复见恶寒汗出，说明不仅里有热，而且表阳亦虚。卫阳原出于下焦，根源于肾，经上焦开

发，以温分肉，肥腠理，熏肌肤，司开合，卫外而为固。今卫阳虚，温煦失职，故恶寒时而又汗出。文中不言心烦诸证，而突出恶寒汗出，并且恶寒在前，汗出在后，这除了有所省略之外，正反映了本证的重点是卫阳虚衰。由于卫出下焦，本源于肾，乃肾阳所化生，故肾阳之虚已意在言外。阳虚则生外寒，据此而称本证为上热下寒的“寒热痞”亦无不可。治用附子泻心汤扶阳固表消痞，为寒热并用之法。

附子泻心汤由附子、大黄、黄连、黄芩四药组成。专煎附子，取其味厚，意在温肾阳以固表，另渍三黄，取其气薄，意在清心胃以消痞。一温阳，一清热，然温阳为主，清热为次，寒热并用，使阴阳调和，则诸证自愈。可谓是寒热异其气，生熟异其性，药虽同行而功效各奏。

这种寒热错杂之证，对初学者往往不易理解，为什么会形成上热下寒的心下痞呢？其原因大致有两方面的可能。其一，凡是上热的，往往容易导致下寒，这是因为人体内的阴阳是处于一个相对平衡的状态，如果在上之阳气被郁而不能下达，则必然导致下焦的阳气不足而生内寒；其二，是有的患者素体肾阳虚衰，又患了心下热痞。由于中焦气机痞塞，阴阳上下不调，而致寒热错杂。总之不论是哪种原因所引起，均与阴阳升降失常有关。

曾治一男性肝炎病患者，突出的表现为口干特甚。始用玉竹、生地、麦冬、沙参、冰糖等滋益阴液之品不效，后加石膏、知母清热生津之药仍未收功。又经细察详问，其证尚有寐差、多梦、舌尖偏红等，遂断为阴阳失调、水火失济之证，疏予黄连阿胶鸡子黄汤，以泻南补北、交通心肾，而取得满意疗效。此例虽非寒热痞证，但很能说明阴阳平衡，心肾相交，水火既济的道理，及其对人体机能活动的重要意义。

本以下之，故心下痞，与泻心汤；痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。（164）

【解析】本条论述水痞的证治，以见痞证有水火之分。

“本以下之，故心下痞”，是讲痞证因于泻下而形成。若以心下痞为主证，则用相应的泻心汤本为正治之法，但服泻心汤后“痞不解”，其原因何在呢？从其人“渴而口燥烦，小便不利”分析，则知本证原为水饮内停，津液不能上承所致。“烦”作甚解，“渴而口燥烦”乃是言口渴、口干而特甚。口渴与小便不利联系起来分析，则知其为水蓄于下，气化不利，故小便不利；气不化津，津液不能输布故口燥而渴。水阻气滞，痞塞于中，气机不利，故作心下痞。其痞因水而作，所以又称“水痞”。

水痞与火痞，心下痞塞虽一，但病因及证治各异：水痞是由水邪内蓄，阻遏气机所致；火痞是由火热邪气留扰中焦所致。水痞有口燥渴，

小便不利之证；火痞则多有心烦乃至吐衄。火痞治用大黄黄连泻心汤泄热消痞已如前述；水痞则当用五苓散助气化，行津液以利小便，从而扩大了五苓散的治疗范围，对痞证的辨证施治也增加了新的证型。

在临床上如果见有小便不利而心下作痞，并见舌体胖大，苔水滑者，即当考虑“水痞”而投以五苓散。

伤寒汗出，解之后，胃中不和，心下痞鞭，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。（165）

生姜泻心汤方：

生姜四两，切 甘草三两，炙 人参三两 干姜一两 黄芩三两 半夏半升，洗 黄连一两 大枣十二枚

上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【解析】本条继上文水痞又论述水气痞的证治。

“伤寒”在此泛指太阳病，包括中风和伤寒。发汗本为正治之法，但如汗不得法，表证虽可解除，脾胃之气却受损伤，或因其人素体脾胃气弱，汗出后部分邪气内陷，影响里气不和，以致造成升降失常，气机痞塞，寒热错杂，而使“胃中不和，心下痞鞭”。一般地说，心下痞当按之软而不痛，此言心下痞硬，是指其人自觉心下痞塞，按之则仅有紧张感，但多无疼痛等证，更不是按之石硬，故仍与结胸证有本质区别。胃主受纳、腐熟，脾主消化运输，脾胃气伤，不能腐熟运化水谷，饮食不消而作腐，胃气不降而上逆，故见“干噎食臭”。干者无物也；噎者暖气也；食臭即饮食未消化的气味。脾胃运化腐熟功能失常，则生水湿痰饮，水走肠间而下注，故见“腹中雷鸣，下利”；“胁下有水气”，指胁下亦有水。由此可知本证的心下痞，为脾胃不和，兼夹水饮，故称“水气痞”或“饮气痞”。除上述见证外，尚可兼见下肢浮肿、胁下作疼、小便不利等证。当治以生姜泻心汤和胃降逆，消水散饮。

生姜泻心汤即半夏泻心汤加生姜，并减少干姜的用量而成，其组方原则与半夏泻心汤基本相同，均属辛开苦降甘调之法。但二方同中有异，异在半夏泻心汤治痞夹痰气；而生姜泻心汤治痞夹水气。由于生姜泻心汤的治疗重点在于胃中不和，胁下有水气，故重用生姜之辛，使其健胃消水散饮。

据临床观察，生姜泻心汤确有治水饮的功效。本论把此方证列于五苓散水痞证之下，就是因为在水饮方面类似五苓散证，但又较五苓散证的水证为轻。《医宗金鉴》对此又加以发挥，认为本方应加茯苓以加强利水的作用，这一主张确是经验之谈。实践证明，凡见有心下痞、暖气食臭、下利、腹中雷鸣、胁下疼痛、或下肢浮肿、小便不多的患者，投以生姜泻心汤加茯苓，多能收到满意效果。

曾治男性患者丁某，年47岁，诉胃脘痞满，时而隆起一包如鸡卵之

大，频频暖气，皆饮食之味，胁下作痛，大便不成形，日行三四次，小便减少，口苦，纳差，并见面目浮肿，脉沉弦滑，舌苔白厚等脉证，辨为脾胃不和，寒热错杂之饮气痞，用生姜泻心汤加茯苓，仅两剂则胃脘隆起之包块消失，诸证已轻，共服八剂而痊愈。

伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞鞭而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚，此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使鞭也，甘草泻心汤主之。（166）

甘草泻心汤方：

甘草四两 黄芩三两 干姜三两 半夏半升，洗 黄连一两 大枣十二枚，擘

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【解析】本条论述误下胃虚、痞利俱甚的证治。

凡表病无论中风、伤寒，都应发汗解表，若妄用下法，则是治疗之谬。误下必伤脾胃之气而引起表邪内陷。脾胃气伤，腐熟运化失职，则水谷不化而下注，故“其人下利日数十行”，肠鸣音可闻而“腹中雷鸣”。此较生姜泻心汤证的腹泻为重，因此反映其脾胃气虚的程度为更甚。脾胃不和，升降失常，气机痞塞，寒热错杂，故见心下痞满、干呕、心烦不得安等证。心烦与下利同见，正是升降失常，阴阳失调，上热下寒，火炎于上而水注于下的表现。医生见有“心下痞鞭而满”，误认为是泻下不尽所致，因此再用泻下，结果使脾胃之气更伤，斡旋升降之力更弱，以致痞满不仅不减，反而更加严重，即所谓“其痞益甚”。言外之意，呕、利、肠鸣等证亦会相应加剧。“此非热结，但以胃中虚，客气上逆，故使鞭也”，这几句话是自注句，说明此心下痞硬，并非胃肠积热所致，当然不能用泻下的方法去治疗。而是由于脾胃气虚，升降失常，气机滞塞，上热下寒，即所谓“客气上逆”所引起，故应以甘草泻心汤和胃补中，消痞止利。

甘草泻心汤原方中本没有人参，根据前半夏、生姜二泻心汤均有人参，《金匱要略》、《千金翼方》、《外台秘要》所载之甘草泻心汤皆有人参；而本证为下后胃虚痞利俱甚之证，故益胃补虚之人参在所必用。若加入人参，本方与半夏泻心汤药味相同，故亦为辛开苦降甘调之

法。因屡经误下，脾胃之气甚虚，治应重在补虚，故重用甘草取其补中益气。脾胃之气得复，升降调和，阴阳通达，则痞证得除，下利自止。

本证与半夏泻心汤证、生姜泻心汤证均有心下痞及呕、利等证，但本证之特点在于痞利俱甚，以此可作鉴别。

伤寒服汤药，下利不止，心下痞鞭。服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚。理中者，理中焦，此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之。复利不止者，当利其小便。（167）

赤石脂禹余粮汤方：

赤石脂一斤，碎 禹余粮一斤，碎

已上二味，以水六升，煮取二升，去滓，三服。

【解析】本条论述下焦不约的下利滑脱证治并兼论治利四法。

病本为伤寒，医者不辨表里虚实即以汤药泻下，因而损伤了脾胃之气。脾胃之气受伤，升降紊乱，气机痞塞，则“心下痞鞭”；清浊不分，故又“下利不止”。这种病理变化，正如《内经》所说“清气在下，则生飧泄；浊气在上，则生**臌**胀”。此时可选用甘草泻心汤或生姜泻心汤，以调和脾胃之气，复其升降之机，使清者升，浊者降，则病愈。但是医不知此，反以他药泻下，使里气更虚，邪气内陷，而致下利不止。医见利不止，认为是中焦虚寒，而投以理中汤。但下利仍然不止，并有加重的趋势，即文中所说：“医以理中与之，利益甚”。这究竟是什么原因，作者自注说：“理中者，理中焦，此利在下焦”，意思是说理中汤是治疗中焦虚寒的方剂，对于下焦关门不固，滑脱不禁之下利证，用理中汤自然不能够取效。本证乃因屡经误下，元气受伤，固摄无权而致，也即如《素问·脉要精微论》所云：“仓廩不藏者，是门户不要也”，所以，下焦不能约束二便而导致的滑脱不禁、下利不止之证，非用赤石脂禹余粮汤填补下焦、固涩止利不可。如果某些下利之证，经用本方后利仍不止并兼见小便不利之证的，则属于清浊不分、水湿偏渗大肠的水湿下利之证，治当利其小便，分清泌浊，则大便可实，可用五苓散。

赤石脂禹余粮汤由赤石脂、禹余粮二药组成，二药均属收涩固脱之药，尤对久泄滑脱之证更为适用，即所谓“涩可去脱”之治。柯韵伯曾指出：“大肠之不固，仍责在胃；关门之不闭，仍责在脾。此二味皆土之精气所结，能实胃而涩肠，盖急以治下焦之标者，实以培中宫之本也。

要之此证是土虚而非火虚，故不宜于姜附。”柯氏所言，既明确了本方证与理中汤证的区别，也说明了与桃花汤证的异同。

本方在临床上，不仅治滑脱下利，还可治脱肛、带下等证。赤石脂、禹余粮二药煎汤不如以末服为好。喻嘉言曾以本方为末与饭拌和服用，治疗下焦下利证，此法可以借鉴。

本条为治疗下利提出四种方法，归纳起来即：心下痞而下利用甘草泻心汤；中焦虚寒下利用理中汤；下焦滑脱下利不止用赤石脂禹余粮汤；水液偏渗、清浊不分而下利，当利其小便，用五苓散。当知仲景设方御变，并非以药试人。

伤寒吐下后发汗，虚烦，脉甚微。八九日，心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒。经脉动惕者，久而成痿。（168）

【解析】本条论述因于误治阳气受伤，以致水气上冲；和阳虚不能化津，而使筋脉失养成痿的病变。

伤寒吐下，本为误治，再行发汗，则津气更伤。阳气虚则阴乘之，故发虚烦，脉甚微。时过八九日，正气未复，阳气益虚，阳不制水则水邪上泛。水邪为患，变化多端，或逆于心下成心下痞硬；或留于胁下使胁下作痛；或上冲咽喉而使咽喉有梗塞之感；或上蒙清阳而致头目眩晕，这是误治变证的一个方面。另一方面，阳虚不能化生津液以濡养筋脉，而水饮之邪又滞于其中，故发生筋惕肉瞤之证。阳气不复则水邪不去，水邪不去则津液不生，而皮、肉、筋、骨、脉失其润濡，久而久之，则肢体痿废而不用。

本条与前之“伤寒若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之”一条联系比较，可以看出苓桂术甘汤证是以水气动泛为主，故见脉沉紧；而本条则以阳气虚衰为重，故见脉甚微。病机证候不同，则治法各异。本证可考虑用苓桂术甘汤合真武汤，以温阳利水，平冲降逆似为合拍。

伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噫气不除者，旋复代赭石汤主之。（169）

旋复代赭石汤方：

旋复花三两 人参二两 生姜五两，切 半夏半升，洗 代赭石一两 大枣十二枚，擘 甘草三两，炙

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎，取三升，温服一升，日三服。

【解析】本条论述胃虚痰气痞塞，噫气不除的证治。

伤寒经发汗、或吐、或下的方法治疗之后，虽表证已解，但脾胃受伤，腐熟运化功能失职，则痰饮内生；土虚木乘，夹痰犯胃，则脾胃不和，升降不利，气机痞塞，胃气上逆，故见心下痞硬，而噫气不除。“噫气不除”包含有三层意思：一是噫气频作，持续不断，久久不能除掉，言其噫气之重；二是虽噫气频作，但心下痞不能解除；三是或曾用泻心汤治疗，而噫气仍然不除。噫气不除是本病的主证，据病情推断，其病机还不仅仅是脾胃不和，痰气痞塞，而且一定挟有肝气上逆，即所谓“土虚而木来乘之”之机。此证再用泻心汤类，将无济于事，必须用调和脾胃、消散痰饮和镇肝降逆的药物方可取效。故以旋覆代赭石汤治疗。

旋覆代赭石汤以旋覆花为主药。凡花者质轻而在上，故有上行的作用，而旋覆花味咸又有下降的作用。升降出入乃气机运行之常道，升降利则气机畅。旋覆花能升能降，既能疏肝利肺，又能散凝结之气而治心下之痞；代赭石是一种矿物药，入肝经有镇肝降逆的作用，配旋覆花之疏利，使肝气条达而下行为顺；半夏、生姜辛辣之品，健胃散水，去痰饮之凝结，故有消痰涤饮、降逆和胃的作用；人参、甘草、大枣甘温扶虚，补中益气，而有强主弱客之义，诸药配伍，既治痰气，又疏肝气，同时还补脾胃之气，扶正与祛邪并用，使脾胃调和，气机舒畅，痰气得消，则痞噫自除。

使用本方时，应注意以下几点：一、因本方属和解之剂，故在煎服时，要去滓重煎，取其药性之和合；二、用药剂量要注意生姜与代赭石的比例，病变重点在于胃，因此要重用生姜以健胃祛痰消痞；而代赭石剂量宜小不宜大，以免其质重直走下焦，而影响疗效；三、妇女妊娠呕吐者，不可用本方，以免代赭石之重镇，有害胎气。

以上几点值得注意，但在临床上对具体问题还要作具体分析，辨其证而施其用。比如食管疾患者，主要表现为噎膈、反胃、呕吐的，用本方时就应重用代赭石以加强其重镇的作用。本方在临床上应用范围很广，特别是用于妇女因情绪波动而引起的肝胃不和之证疗效甚佳。临床实践证明，用于治疗暖气不除，不兼有心下痞硬的病证同样有较理想的效果，也可用于治疗呕吐等证。

下后，不可更行桂枝汤。若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏子甘草石膏汤。（170）

【解析】本条与第64条所论内容相同，论述误下太阳之后，邪热内陷于肺的证治。

从“下后，不可更行桂枝汤”看，原为太阳病，因误下而致表邪内陷。证见“汗出而喘，无大热”，为表邪化热迫肺，邪热壅盛，肺气不利之证，故不可再与桂枝汤或桂枝加厚朴杏子汤了，而当与麻黄杏子甘草石膏汤清肺以平喘。本证与第64条相同，不同之处仅在于一是汗后，一是下后而已。

本方证列于此处，似与上下文皆无联系，疑原文排列有误。

太阳病，外证未除而数下之，遂协热而利。利下不止，心下痞鞭，表里不解者，桂枝人参汤主之。（171）

桂枝人参汤方：

桂枝四两，去皮 甘草四两，炙 白术三两 人参三两 干姜三两

上五味，以水九升，先煮四味，取五升，内桂更煮，取三升，温服一升，日再、夜一服。

【解析】本条论述太阴虚寒兼太阳表邪不解的证治。

太阳病为表病，应以汗法解表，即使是表里同病，亦应先解表，后攻里。若外证未除，即用下法攻里，乃属误治。更何况“数下之”，即非只一次误下，致使表证不解而里气先伤。脾阳被伤，运化失司，升降紊乱，气机痞塞，因而出现“利下不止，心下痞鞭”之证。这种既有太阳表证存在，同时又有下利不止的病证，则称为“协热利”。此“协热”，指并见发热之表证而言。因其“表里不解”，故以桂枝人参汤，温中解表而表里同治。

桂枝人参汤即理中汤（又名人参汤）加桂枝。方用干姜、白术温中以去寒湿之凝；人参、甘草补中益气以治脾气之虚；桂枝以解太阳在表之邪气。本方煎服法要求先煎人参汤四味，使其发挥温中散寒、补脾益气的效用；后下桂枝，使其先越出表邪，而不受人参、干姜的羁绊。否则五药同煎，会使桂枝芳香走表主力变为温里之用，而达不到表里两解的目的。

在《伤寒论》中，讲表证误下致协热下利的只有两条，须要进行对比：第35条之葛根黄连黄芩汤证是表里皆热的协热下利，故见脉促、喘而汗出、热利黏秽的热证；本条是表里皆寒的“协热下利”，故见心下痞

硬、下利稀溏的寒证。二者皆名“协热利”，但有寒热虚实之不同。

第169条所述旋覆代赭石汤证的病变重点在于胃，以心下痞硬、噫气不除为主证；本条的病变重点在于脾，故以心下痞硬、下利不止为主证。一在胃，一在脾，病位不同，见证各异。联系心下痞诸条，可以看出，无论胃气不和或脾气不和都可发生心下痞证。因此调理脾胃，畅达升降之机，则为治心下痞之大法。

伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也，不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。（172）

【解析】本条论述热痞兼表证不解的标本缓急治法。

伤寒为病在表，即使有里证，也当先以汗解。今“大下后，复发汗”，汗下失序，实属误治。大下则阳邪内陷，热滞中焦，阻遏气机，从而导致心下痞硬。此时虽经发汗，但因内有邪热，则发汗不足以解表邪，故表犹未解，可仍见发热、恶寒之证。条文中无“发热”一症，有的注家认为：心下痞而兼阳虚的附子泻心汤证，其主要表现是恶寒汗出，而没有发热，为了便于鉴别，故本证应有“发热”一症。此证既有太阳表证的发热、恶寒，又有热滞于中的心下痞，言外之意，还有心烦、大便不爽、小便黄赤等证。对此，既不能用表里两解之法，亦不能单纯先治热痞。因治热痞必用苦寒之大黄、黄连，其不仅有碍于解表，且有引邪入里之弊，故应顺其病机而先解表，解表以桂枝汤。当表解后方可“攻痞”，攻痞则用大黄黄连泻心汤。

本条与上条相比：桂枝人参汤证的表里不解是脾气虚寒而兼表，用温中益气之药无碍于解表，反能助正祛邪，所以用表里两解之法是适宜的；而本条所论则是邪热内陷之痞证而兼表证，故治痞以祛邪为主，先发汗解表，然后攻痞方为妥当。由此可以体会到：表里同病，里虚者应先扶正；里实者应先解表，也即体现出虚人伤寒建其中，实人伤寒发其汗的治疗原则。

伤寒，发热，汗出不解，心下痞鞭，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。（173）

【解析】本条论述少阳兼阳明里实的证治。

伤寒为病在表，发汗之后，其热当解。今“发热，汗出不解”，并见“心下痞鞭，呕吐而下利”等证，说明邪已离太阳而有传经入里之变。从治用大柴胡汤，可知邪热并入少阳、阳明二经。“心下痞鞭”应以赵本“心中痞鞭”为是，指心胸痞闷滞塞之感，乃因少阳气郁，枢机不利所

致。肝胆气火迫于肠胃，迫使胃气不和而上逆，则呕吐频作；迫于大肠，则下利黏秽而不爽。联系前面第109条，可以看出，大柴胡汤证常见有心下急、心中痞硬等证，说明其病变部位较之小柴胡汤更偏于里。但因其证以呕吐为主，故又表明未尽入于里，病邪仍未离少阳，因此不用承气剂而仍用柴胡剂。同时，还可以看出，大柴胡汤证不仅有大便秘结，亦有热利而不爽者。个别注家，如《医宗金鉴》认为“呕吐而下利”的“下”字，是“不”字之误，当改。其理由是下利不能用大柴胡汤，这种认识显然是没有根据的。考《伤寒论》用通下法治疗热利，不仅有大柴胡汤之一法，他如大、小承气汤治疗热结旁流之自利清水及热利等证，也比比皆是。本证属少阳气火内迫阳明所致之下利，用大柴胡汤以去凝滞之邪，疏利肝胆之郁热，使胃肠之气一利，则下利等证自止。

大柴胡汤证与桂枝人参汤证均有心中或心下痞硬、下利之证。但大柴胡汤证发热而不恶寒，下利黏秽不爽，以呕吐为主证，病属少阳与阳明之郁热结滞，治以祛邪为主，和解与攻里并施；而桂枝人参汤证以发热恶寒、下利稀溏为主证，病属太阳太阴同病，表里皆寒，治以扶正为主，解表与温里同用。两相对比，有表里寒热虚实之别，前后互参，以见辨证之全。

病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞鞭，气上冲咽喉，不得息者，此为胸有寒也，当吐之，宜瓜蒂散。（174）

瓜蒂散方：

瓜蒂一分，熬黄 赤小豆一分

上二味，各别捣筛，为散已，合治之，取一钱匕。以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁和散，温顿服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血虚家，不可与瓜蒂散。

【解析】本条论述胸中痰实证治。

“此为胸有寒也”，是自注之词，同时也阐明了本证的病机。这里的“寒”字，有两个意思，一是泛指邪气，主要指阴寒之邪；二是指“痰”邪而言。因在汉代时，还没有“痰”字，《金匱要略》所谓之“痰饮”原为“淡饮”。淡饮者，淡薄之饮也。魏至梁代的陶弘景写《神农本草经别录》，才首见痰字。由于痰饮亦属阴邪，故这里的“寒”可以说具有双重意思。痰作为病理产物，乃生于脾，多因脾虚失运而生，故有“脾为生痰之源”的说法。但作为致病因素，则可以流注于人体各个部

位而为病。特别是痰实邪气最易上伤阳位。在人体来说，下为阴上为阳，胸居阳位，为上气海，是阳气会聚之处。卫阳之气出于下焦，开发于上焦，即由胸中开发，以温分肉、熏肌肤、肥腠理、司开合。若胸中有痰实邪气阻遏，则胸阳不能正常地宣发，因而出现发热、汗出、恶风等营卫不和的类似桂枝汤证的证候。而真正的桂枝汤证，不仅有太阳之气上冲的表证，而且还应见太阳经脉不利之证。足太阳经脉从头至足，循行于项背，故“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒”，即桂枝汤证当见头项强痛，寸关尺三部脉俱浮等。而今虽“病如桂枝证”，但“头不痛，项不强”，只寸脉微浮，说明并非真正的桂枝证。《濒湖脉学》云：“寸浮头痛眩生风，或有风痰聚在胸”。寸脉候胸中、上焦，风痰邪气聚于上焦胸中，正气抗邪有上越外出之机，故寸脉见浮象。寸脉微浮，言外之意，关尺之脉则见沉象。这是由于上焦为痰实阻滞，阳气不能下达，中下焦阳气闭塞，故关尺脉沉。痰阻胸膈，气机不利，故胸中痞硬，正气拒邪于外，胸中痰气上逆，所以气上冲咽喉不得息，而有欲吐而不能吐之状。根据《素问·阴阳应象大论》所指出的“其高者，因而越之”的治疗法则，本证应因势利导，用瓜蒂散吐之。吐出胸中痰实邪气，则胸阳得伸，其病自愈。

瓜蒂散用瓜蒂和赤小豆各“一分”，这里的“一分”，是等量的意思，不是剂量单位。瓜蒂又名苦丁香，味极苦，涌吐力最强，为催吐之要药；赤小豆味酸苦，能行水消肿，与瓜蒂相伍有酸苦涌泄之功；香豉清轻宣泄，载药上浮，以其煮汤合散，有助涌吐之力。因本方涌吐之力甚强，故使用时应得法，提出以下几点注意事项，可供参考：

第一，凡催吐药物服后，可鼓动全身阳气浮动上冲，故可见头目眩晕、汗出等反应。应令病人勿动，或闭目以待之，并应选择避风安全处，以免跌仆或汗出受风。

第二，在吐之前，可用宽布腰带勒紧腹部，借增腹压而助其涌吐。

第三，若确有痰实，但服药后而不吐反见心烦难以忍耐者，可以用物探喉以催吐，或少进白糖，以促其吐。得快吐乃止，不可多服。若因药力不足，可稍稍加量。

第四，若痰实吐出，大邪已去，而吐势不止，可以葱白煎汤饮服而抑制其吐。

第五，吐法势猛，虽能去邪，也易伤正，特别是容易伤胃气与津液，故久病、年老、体弱者不可与之。仲景告诫“诸亡血虚家，不可与”，就是这个意思。

汗、吐、下乃去邪之三法。病在表者，汗而发之；病在上者，因而

越之；病在里者，下夺而竭之。张子和《儒门事亲》论汗吐下之法很为全面，现在临床用汗、下二法较常见，唯涌吐之法却很少运用。汪昂曾对此作过批评，他说：“今人惟知汗下而吐法绝置不用，遇邪在上焦及当吐者不行涌越，致邪塞而成坏证，轻病致重，重病致死多矣。时人背弃古法枉人性命可痛也”。我们应当很好地继承古人留给我们的各种行之有效的治疗手段和方法，并在临床实践中不断地总结发扬，不能因为吐法有伤正气之弊就弃置不用。金元四大家之一的朱丹溪，曾用吐法治疗小便不通，获得很好的疗效，这是开上窍以导下窍之法。这些经验，均可作为我们的借鉴。

病胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹，入阴筋者，此名藏结。死。（175）

【解析】本条论述三阴脏结的死证。

“病胁下素有痞，连在脐傍”，指病人平素在胁下就有痞积或痞块，连在脐傍部位，说明脏结日久以致气血郁滞，脉络闭阻。“痛引少腹，入阴筋”，言其发作时的症状。引，牵引、收引的意思，即发作的时候，从脐旁到少腹牵引疼痛，甚至牵引阴筋内抽；“阴筋”指男性生殖器。从上述证候看其病变部位，则已涉及脏阴。因胁下为厥阴肝之部，脐傍乃太阴脾所主，少腹属下焦为肝肾所居，而肝脉又络阴器，肾开窍于二阴，阴筋也关系于肝肾两脏。肝脾肾三脏无阳以温化，阴寒凝结于三阴，其病情危重可知，故云“此名藏结。死”。据一些老大夫的经验介绍，此证在发作时用大艾团灸丹田、气海，或可救治。

伤寒病，若吐、若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。（176）

【解析】本条论述阳明热证兼气阴两伤的证治。

伤寒病在表，误用吐、下之法，致使疾病延迟七八日不解。误吐则使津液亡于上；误下又使津液亡于下，上下分消，终致胃中津液匮乏，而在表之邪得以乘机入里。“热结在里”，即是邪已离开太阳之表而聚于阳明之里的意思。阳明病有经证、热证、腑证之分。葛根汤证乃是阳明之经证；承气汤证则是阳明之腑证。本条所论，既非经证，也非腑证，而是邪热弥漫周身，充斥于表里内外的阳明热证。阳明之热为里热，热由内向外而发，因而形成所谓“表里俱热”。热由里向外蒸腾，逼迫津液向外发泄，故必见汗出。热蒸汗出，则气随津泄，气阴两伤，表气不固，因而有“时时恶风”的证候。热盛津伤，胃中干燥，故其人大渴。“欲饮水数升”，是形容渴饮之甚；“舌上干燥而烦”，是形容津伤之

甚，连舌上都见干燥。“舌上干燥”，医者不仅可望而知之，若以净手摸其舌面，也可感到干燥无津。“舌上干燥而烦”的“烦”字，有心烦与燥渴至甚的两层意思，都是热盛津伤的必然见证。

由此可见，此属阳明之邪热弥漫周身、充斥内外、津液匮乏、气阴两伤之证，应以白虎加人参汤为治。方用白虎汤清热生津，加人参以补气生津止渴，使邪热得清，气阴得复，诸证即愈。

伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。
(177)

【解析】本条承上条再论阳明热甚、气阴两伤证治。

阳明之热邪，有偏盛于表者，有偏盛于里者，亦有表里俱盛者。本条所论乃阳明热邪偏盛于里，里热较盛而体表之热较逊，故谓“伤寒无大热”。但无大热仅是相对之词，说明肌表热势不甚。口燥渴是热伤津液的反映，为白虎加人参汤证的辨证眼目。胃络上通于心，阳明邪热扰心，故烦。“背微恶寒”与上条“时时恶风”的病机相同，只是表现形式不同。由于背为阳之府，是阳气会聚的地方，故当热迫汗出，津气两伤，卫阳失于固密和温煦职能时，则背部恶风寒最为明显。这里的恶寒乃恶风的互词。治疗仍以白虎加人参汤清热益气生津为宜。

本证因有“无大热”和“背微恶寒”之证，而易与少阴阳虚证混淆，故在临床辨证时应注意鉴别。少阴阳虚证虽也见背恶寒，但必是口中和而不燥渴，并见厥逆脉微等虚寒证象，与本证截然不同。

伤寒脉浮，发热无汗，其表不解者，不可与白虎汤。渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。(178)

【解析】本条论述白虎汤的禁忌证和使用白虎汤的原则。

脉浮主表，与发热无汗并见，是为太阳伤寒，而恶寒身疼等表实证自在言外。邪在表当治以汗法，此时即或兼见烦渴等里热之证，亦应表里两解，或先解表后清里，而不可先以白虎汤清其里热，这就是“其表不解者，不可与白虎汤”的用意。这是因为白虎汤是甘寒清热的重剂，表寒证用之，每可冰伏表邪，郁遏阳气，甚或引邪内陷而病必不除。过去在临床上就曾有过这样的教训。曾诊治一邻居患者周某，女，感冒发热不退。初诊辨证未确，就使用辛凉重剂的银翘散加石膏。服药后病反不解，而发热更甚。再诊仍不醒悟，反认为石膏剂量犹轻，而又继续加大药量，结果不仅热仍不退，反而出现了神昏谵语之证。后来患家另请一位老医生诊治，经详细检查并问清病情之后，指出此病得之石膏用之太早，使邪气冰伏不得透出，急以鸡冠血合黄酒、蜂蜜让病人饮服，然

后盖被取汗。果然服后汗出，胸前见有大片针尖大小的皮疹，而内陷之邪得以透发，则热退神安。从这一案例，足以说明表邪不解，过早使用石膏的危害，结合本文体会，更可加深理解。

下段的“渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之”，则说明里热已成，表证已解，而出现津气两伤的证候，则应治以白虎加人参汤。亦可以理解为见渴欲饮水，无表证，即使不见大热、心烦之证，亦可用白虎加人参汤。现在临床上治疗糖尿病，患者口干渴较甚而饮水颇多，但身上并不发热，而投以白虎加人参汤取得效果，这样的用法，可能就源于此。

太阳少阳并病，心下鞭，颈项强而眩者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎勿下之。（179）

【解析】本条与第150条相互呼应，共论太少并病的治法及禁忌。

太少并病为先病太阳不解而后又病少阳。“颈项强”是太阳经邪不解；“心下鞭”、眩冒是少阳之气不和。因少阳禁汗，故虽有太阳经邪不解，亦不可发汗而解太阳之邪。若误发其汗则伤津液，以致胃中干燥，邪转阳明而见谵语。另外，虽然有心下硬、眩冒等少阳邪气偏结于里的证候，亦不可用下法，因下法必用苦寒之品，而有碍于太阳经邪的解除。汗法与下法均不适宜，则只能选用刺法。如刺大椎、肺俞以解太阳之经邪；刺肝俞以解少阳之邪，从而达到太少两解的目的。“慎勿下之”是叮咛之词，嘱医生虽见心下硬之证，亦不要误认为是实证而用下法。误下则太阳之邪乘虚入里，而又有形成结胸的可能。

本条与第150条的意思基本相同。唯第150条论太少并病禁汗，发汗则谵语；本条则述太少并病禁下，下之则有结胸之变。

太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤；若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。（180）

黄芩汤方：

黄芩三两 甘草二两，炙 芍药二两 大枣十二枚，擘

上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。若呕者，加半夏半升，生姜三两。

黄芩加半夏生姜汤方：

于黄芩汤方内，加半夏半升，生姜一两半，余依黄芩汤法服。

【解析】本条论述太少合病下利的证治。

合病为两经以上同时发病，而无先后次第之分。本条论太阳与少阳合病，即太阳与少阳的病证同时俱见。“自下利”，即未经泻下而自发的下利，为本条合病的主证，乃因少阳火郁不伸，邪热内迫阳明而下趋大肠所致。又因少阳疏泄不利，气机不畅，其下利则往往兼有大便不爽、下重难通、肛门灼热，甚或有红白黏秽的特点。此条合病之治，若发汗以解表邪，则有伤津化燥之弊；若泻下以除里热，则又有导致表邪内陷而成结胸之虑。唯以黄芩汤先清少阳之热，则肠胃之热方能解除而下利可止。下利止则肠胃之气和，反过来又有利于少阳之气的疏泄。少阳枢机畅利，则太阳之邪也得以向外宣泄。

黄芩汤用黄芩之苦寒，以清肝胆之热；芍药能养肝胆之阴，同时能于土中伐木，以制肝胆木气之横逆，两药相合，为治热利之主药。甘草、大枣益气滋液，而顾护正气。

若少阳邪热逆于胃，胃气上逆并挟有痰饮而作呕的，于黄芩汤方中加半夏、生姜和胃降逆，蠲饮止呕。黄芩汤加半夏、生姜亦可看做是小柴胡汤的变方，因热已不在半表而入于半里，故去柴胡而仅用黄芩，证非胃实，然亦非胃虚，故不须人参之补。

黄芩汤现代临床上多用于治疗痢疾。后世治疗痢疾的名方芍药汤，即由黄芩汤发展而来。故《医方集解》称此方为“万世治痢之祖”。

《伤寒论》对合病的下利每每随证设方。如太阳与阳明合病下利者，用葛根汤；少阳与阳明合病下利者，用大柴胡汤；本条是太阳与少

阳合病下利，用黄芩汤。充分体现了张仲景辨证论治的学术思想。

伤寒胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。
(181)

黄连汤方：

黄连 甘草炙 干姜 桂枝去皮，各三两 人参二两 半夏半升，洗 大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服一升，日三服，夜二服。

【解析】本条论述上热下寒，腹痛欲呕吐的证治。

“伤寒”在此泛指感受外邪，非专指太阳伤寒。“胸中有热”，即胸中有邪热；“胃中有邪气”，在这里指胃中有寒邪。亦有认为“胸中有热，胃中有邪气”，是指胃热肠寒之证。总之是属于上热下寒的病证。上有热，胃失和降而上逆，故恶心而欲呕吐；下有寒则使气血凝滞，故见腹中疼痛。凡寒热错杂之证无不与阴阳的升降失调有关，故阳在上不能下交于阴，则下寒者自寒；阴在下不能上交于阳，则上热者自热。其治用黄连汤清上温下，平调寒热，以交通阴阳。

黄连汤以黄连清在上之热；同时用干姜温在下之寒；桂枝既能通上下阴阳之气，又能和解在表之余邪；参、草、枣益胃安中，以复中焦之升降；半夏降逆止呕，以和中焦之阴阳，本方实即半夏泻心汤去黄芩加桂枝而成，故与半夏泻心汤同为辛开苦降甘调之剂。其不同之处，本方用桂枝，功偏于温通，多用治上热下寒、表里不和，而以腹痛为主的病证；半夏泻心汤有黄芩无桂枝，功偏于清热，多用治脾胃不和、升降失常、气机痞塞，以心下痞为主的病证。简言之，本方主治寒热格拒于上下，而泻心汤主治寒热痞塞于中焦。

据临床观察，由于本证属胃中有寒，中阳不能温化，可以出现腹泻下利之证。但此下利与上条之肝胆热滞，疏泄不利所引起的热性下利不同。故在治法上既以黄连汤清上温下而交通阴阳，又以黄芩汤清利肝胆而坚阴。

伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而_㼶者，桂枝附子汤主之。(182)

桂枝附子汤方：

（方载原书183条下，今移至此）

桂枝四两，去皮 附子三枚，炮，去皮，破八片 生姜三两，切 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

【解析】本条论述伤寒类证风湿伤于肌表的证治。

伤寒八九日，言患病日久而不愈。其原因可从两方面加以考虑，或因其人正气不足，不能及时拒邪于外，或因邪气杂糅而纠缠难解，本证则两种因素兼有。风寒与湿邪相搏，痹着于体表，影响营卫之调和，阻碍气血之运行，故见身体疼痛以致到了难以转侧的程度。“不呕”，为无少阳证；“不渴”，为无阳明证，由此可知里和无病。脉浮为风寒湿在表，虚主卫气不足，**濡**主寒湿之邪不解。风、寒、湿三气杂合而为痹，患者卫阳复虚，邪盛而正衰，故使病证缠绵日久而留连不愈。“身体疼烦”，形似伤寒，实非伤寒，故为伤寒类证。治以桂枝附子汤温经祛风，温化寒湿之邪。

桂枝附子汤即桂枝汤去芍药加附子。方用桂枝既能疏散风寒邪气，又能温经通阳；附子辛热，善温经扶阳，散寒逐湿以止疼痛；生姜助附子、桂枝以温散风寒湿三邪；甘草、大枣甘温以缓桂附之性，且扶正气之虚，合生姜则辛甘化阳以抑阴，又能健脾和中以行津液。本方与桂枝去芍药加附子汤药味完全相同，唯桂附用量较上方为大，故二方主治的重点也就不同。彼方主治胸阳不振兼表阳不足，以脉促、胸闷、微恶寒为主证；此方主治阳气不足，风湿困于肌表，以身疼烦、不能自转侧为主证。

若其人大便鞅，小便自利者，去桂枝加白术汤主之。（183）

去桂加白术汤方：

（本方成本未录，今依赵本补入）

附子三枚，炮，去皮，破 白术四两 生姜三两，切 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水六升，煮取两升，去滓，分温三服。初一服，其人身

如痹，半日许复服之，三服都尽，其人如冒状，勿怪。此以附子、术并走皮内，逐水气未得除，故使之耳，法当加桂四两。此本一方二法：以大便鞣、小便自利，去桂也；以大便不鞣、小便不利，当加桂。附子三枚，恐多也。虚弱家及产妇，宜减之。

【解析】本文承上条继论寒湿痹证的治法。

此条在赵开美本与上条原为一条。联系上下文，可知本条之“大便鞣，小便自利”，是在上条见证基础上的发展变化，反过来亦可了解到上条之桂枝附子汤证，当见大便溏，小便不利。今其人大便硬，小便自利，若见于服桂枝附子汤之后，说明阳气通，湿邪减，气化已行，不需再用通阳化气走表之桂枝，加用白术健脾燥湿以善其后；若本为大便硬，小便自利，则反映湿重困脾，脾运不健，津液不能还于胃中，故亦当于桂枝附子汤中去桂枝以免走散津液，加白术燥湿健脾引津液还于胃中。

桂枝附子去桂加白术汤，与《金匱要略》的白术附子汤组成药味相同，只是剂量不同。本方以温里而达到祛表的目的，为专治皮下水湿寒气而设。白术为脾家之主药，功善去湿痹而行津液，故既可止泻，又可利便。附子去寒邪而温阳气。白术协附子并走皮内，以搜逐在表之寒湿。姜枣调营卫促使药力行于肌表。

服用本方后，或出现身如痹状；或药尽而其人如冒状者，皆勿怪。此乃附子、白术并走皮内，欲逐水气而尚不得除所致，俟病邪得解，则诸证自安。或为增强温化水气的力量，亦可再加桂枝以通阳化气。这样就形成了一方二法，即大便硬，小便自利，则去桂；大便不硬，小便不利，当加桂。本方附子用至三枚其量甚大，故虚弱之人及产妇则宜减量或者慎用。

风湿相搏，骨节烦疼，掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

（184）

甘草附子汤方：

甘草二两，炙 附子二枚，炮，去皮，破 白术二两 桂枝四两，去皮

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。初服得微汗则解。能食，汗出复烦者，服五合，恐一升多者，宜服六七合为

妙。

【解析】本条论述风湿留于关节的证治。

“风湿相搏”，应体会为风、寒、湿三邪互相搏结。寒性主收引，主凝滞，而使气血闭阻，经脉不通，则疼痛突出地严重；湿性黏腻，滞着关节而不行，筋脉附于关节，寒湿相搏，筋脉拘挛，故肢体关节牵引疼痛，甚则难以屈伸；寒湿留于关节，经脉气血阻滞，故“近之则痛剧”；风胜于表，卫阳不固，所以汗出；汗出肌疏，不胜风袭，故恶风不欲去衣；湿阻于里，三焦气化不利，所以在上焦表现为呼吸短气；在下焦表现为小便不利；湿邪溢于肌肤，则身微肿而沉重。治用甘草附子汤温经散寒，祛风除湿，通痹以止痛。

甘草附子汤由甘草、附子、白术、桂枝组成。方用附子温经助阳，祛逐寒湿；白术苦温，健脾燥湿行水；桂枝辛温与术附同用，既能祛风通络，又能通阳以化气。独以甘草名方，取其性味甘温，能缓和诸药，使峻烈之剂缓缓发挥作用，以祛尽风湿之邪。本方的术附用量均比前方为少，每次服药仅六七合，又不欲尽剂，其用意在于缓行。风湿之邪，因风邪易去，而湿邪难除，故用药峻行缓之法，可使风湿之邪并去而不留。

本方用于临床，治疗风寒湿痹而兼有心脏病的患者，如见有汗出、短气、心悸、胸闷、背冷等证，多能取效。

以上三条所论，实属杂病范围。故《金匱要略》亦载有此方。本论列此方证的用意，是为了与伤寒互相鉴别，故以类证的形式列出。上方证，并作一处比较：桂枝附子汤乃为风湿偏重于表而设；去桂加术汤乃为风湿偏重于肌肉而设；甘草附子汤则为风湿偏重于关节而设，三方虽皆治风寒湿痹，但其病位各有不同，应注意区别选用。

伤寒脉浮滑，此表有热、里有寒，白虎汤主之。（185）

白虎汤方：

知母六两 石膏一斤，碎 甘草二两 粳米六合

上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓，温服一升，日三服。

【解析】本条论述阳明热而未实的脉证治法。

对本条注家意见颇不一致，其争论焦点在于对“表有热，里有寒”的

解释，特别是对“里有寒”的提法认为不妥。因为以方测证，白虎汤主治阳明里热人所共知，考本论有关白虎汤证的条文，均讲的是“表里俱热”，或“里有热”。再从临床实践来看，白虎汤证均以阳明气分热邪充斥表里内外为特点。所以本条之“表有热，里有寒”当改为“表里有热”或“表里俱热”，才合乎情理。

本条在写法上详于脉而略于证。“脉浮滑”，不仅言其脉象，而且也是对病机的概括。脉滑主阳盛，气血充盈；兼见浮象，是气血外达，阳盛于表的表现。本论《辨脉法》谓：“凡脉大、浮、数、动、滑，此名阳也”，脉见“浮、滑”，表明其证属阳，反映了阳热充盛，与表里俱热相合。文中不言其证，乃简略之笔。因白虎汤证为阳明里热蒸腾，热于内而见于外，充斥于表里，弥漫于周身，故除见浮滑或洪大的脉象外，言外之意，尚有大热、汗出、口渴，以及心烦等气分大热的见证。若此种病情未及时控制而发展下去，则热伤气而汗伤津，导致气阴两伤，则必以白虎加人参汤拯治。而本条所论乃气分热势正盛而正气尚未虚衰，故只以白虎汤清气分之热则愈。

白虎汤用知母，既能清热，又能滋养阴液；石膏味辛甘性大寒，专清肺胃气分之热，且清热而不伤津液。用炙甘草和粳米既能补后天而滋化源，同时又可节制石膏、知母之大寒，使热去而不伤胃。

伤寒脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。（186）

炙甘草汤方：

炙甘草四两，炙 生姜三两，切 桂枝三两，去皮 人参二两 生地黄一斤 阿胶二两 麦门冬半升，去心 麻子仁半升 大枣十二枚，擘

上九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，内胶烊消尽，温服一升，日三服，一名复脉汤。

【解析】本条论述太阳之邪传入少阴而阴阳两虚的证治。

病本于伤寒。伤寒一证，若不及时治疗，其变化多端。或传少阳，或传阳明，或传少阴，或形成并病等等。太阳与少阴为表里，脏腑相通，经脉相连。若太阳之邪不解，正气益虚，很容易循经传入少阴。少阴为心肾两脏，若不传足少阴肾，便传于手少阴心。若心阴阳气血俱虚，而心无所养，则有心慌慌然悸动不安之感。“动”，言其甚也。“动悸”，形容心跳动得很厉害而非同一般。

结代脉，即脉律不整而有歇止的一类脉象，下条将作专门介绍。引起结代脉的原因很多，或因瘀血，或因痰阻，或因水遏，或因气血虚衰等等。本条之脉结代，则属气血虚衰，运行无力，脉搏不续所致。心为五脏六腑之大主，如《素问·灵兰秘典论》所云“心者，君主之官也，神明出焉”，又云“主明则下安，以此养生则寿……主不明则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤”。足见心脏之气血虚衰实非同小可。故急以炙甘草汤滋养心血而通阳复脉。

炙甘草汤用炙甘草、人参、大枣补中焦、滋化源，化生气血，以复脉之本；用生地、麦冬、阿胶、麻子仁补心血、滋心阴以充脉之体；阴不得阳则不生，阳不得阴则不长，故加桂枝、生姜、清酒（米酒）通阳以利血脉，又可滋阴而无滞结之患，以达到复脉宁心之目的，故本方又名复脉汤。

根据《名医别录》记载：甘草能通经脉利血气。现代医学从甘草中提取出甘草苷，有强心的作用。因此，其对心脏气血虚衰患者确有一定疗效。柯韵伯认为本方中应去麻子仁加酸枣仁。根据临床用药观察，若于本方中加五味子，取生脉散之意，则更为恰当，且能提高疗效。

炙甘草汤证列于“太阳病篇”之末，有其较深刻的意义，使我们可以看到伤寒由表及里的病变过程，特别是以少阴虚衰，气血不足的病证结尾，更是突出地反映了太阳与少阴的表里关系在病理变化上的联系。这一安排不仅体现了张仲景的辨证思想，而且也从一个侧面揭示了《伤寒论》辨证论治由阳入阴的理论体系，确实发人深思，值得推敲。

脉按之来缓，而时一止复来者，名曰结。又脉来动而中止，更来小数，中有还者反动，名曰结阴也；脉来动而中止，不能自还，因而复动，名曰代阴也。得此脉者，必难治。（187）

【解析】本条论述结代脉象的特点，并以此判断疾病的预后。

本条考赵本与成本，在句读方面略有不同。两相比较，还是以赵本为要。“名曰结阴也”，应为“名曰结，阴也”。“名曰代阴也”，应为“名曰代，阴也”。

结代脉属于间歇脉，以脉有歇止为主要特点。间歇脉有三种，即促、结、代。数而中止者为促脉；结脉与代脉则属于缓而中止的一类，但二者又有区别。若脉来迟缓，时有一次歇止，歇止后又能搏动者，此为结脉。结，是阻滞不通的意思。气血凝滞，脉道不利，故脉搏动间有止。因心跳未息，故止后之一动与下次搏动间隔较小，表现为“更来小数”。所谓小数，其实不是真正的数脉，而是止后能还，止中反动的脉象。《濒湖脉学》谓：“结脉缓而时一止，独阴偏盛欲亡阳”，说明结脉

的出现，往往由于正气虚衰，阳气不足，阴寒偏盛，气血凝滞所致。其脉属阴，其证属阴，故为“阴也”。若脉搏动时有一止，歇止之后“不能自还”，即不能随即再动，而要间隔较长时间再动，或待下次搏动而复动者，即为代脉。代，是代替的意思，反映心脏气血虚甚，较结脉更为严重。如《濒湖脉学》云：“代脉都因元气衰，腹痛泄利下元亏”，说明代脉的出现，总是由于脏气虚衰，元气不足所致，故也属阴脉，而见于阴证。

总之，结脉与代脉均属阴脉，主脏气虚衰，正气亏损，若见此脉，病多难已，故曰“得此脉者，必难治。”

【小结】

本篇共有原文52条，其中的主要内容有：结胸证及其类证；心下痞证及其类证；热结阳明，邪热充斥表里内外，弥漫周身而气阴两伤的白虎加人参汤证及其禁忌证；在白虎加人参汤证之后又论述了太少并病与合病的刺法及黄芩汤之清法；又论述了上热下寒的黄连汤证；风寒湿痹的伤寒类证；最后以脉结代、心动悸的少阴病结束，从而反映了太阳病与各相关病证的内在联系，极大地丰富了“太阳病篇”辨证论治的内容。

辨阳明病脉证并治法

【概说】

阳明指足阳明胃和手阳明大肠。阳明是阳气昌盛的意思。太阳为三阳，其气布于周身体表，故言其大；少阳为一阳，其气升发疏泄，而处于萌芽阶段，故言其小；而阳明为二阳，居于太阳与少阳之间，故言其盛，所以有“两阳合明”之说。

阳明又代表着一定的脏腑经络。手阳明经脉起于食指，循臂外侧上肩，下入缺盆，络肺，下膈，属大肠，说明了大肠经脉与肺相连。足阳明经脉，起于鼻之交頄中，下循鼻外，入上齿中，还出挟口，下交承浆……其支者……下膈属胃，络脾，说明了胃之经脉与脾相连，因而构成了肺与大肠相表里，脾与胃相表里的关系。阳明之腑即足阳明胃与手阳明大肠。胃与脾以膜相连，经脉相通，其关系亦非常密切，而胃与大肠又上下直接相通，故其关系则更为密切。

就其生理特点而言，阳明属土，居于中焦，为水谷之海，又为多气多血之经。在脾的协同作用下，既能容纳水谷，又能营养四旁，故脾胃为后天之本。如《中藏经》云：“胃气壮，五脏六腑皆壮也。”胃之所以能不断容纳五谷，在于胃之阳气有腐熟的作用，大肠有传化物的作用。在正常情况下，六腑以通为顺，故满而不能实。阳明属里，容纳两阳之气。又胃气主降，而肠胃之气以下行为顺，故有阳明主阖之说。饮食入胃则胃实而肠虚，食物下移于肠则肠实而胃虚，虚实互相交替，腑气得通顺，肠胃中糟粕方能及时排出体外而不至于凝滞。

阳明之气强盛，抗邪有力，邪入阳明，则多表现为大热、大实之证，故为外感热性病的极期阶段。阳明病的形成，有以下两种情况：

第一，原发的阳明病：为阳明在经之邪不解，随经入腑而构成胃家实证，或者因于胃有宿食，肠中积滞先行化热，感邪之后，不待传变，即可化燥而成阳明病。

第二，续发的阳明病：多为太阳或少阳之邪不解而内传阳明，或由于发汗以及或吐或下之后，津液受伤，胃气失和，邪气化燥成实而转属阳明。

阳明病，以里实证为主。里为病位，实为病性。《丹溪心法》

说：“欲知其内者，当以观乎外；诊于外者，斯以知其内。盖有诸内者，必形诸外。”由于阳明主燥，其阳气强盛，若邪热入内，最易伤津而化为燥热。燥热凝结肠胃，腑气不通，大便不下，因而肠实胃满。其表现于内则有大便燥结，腹部胀满，绕脐疼痛，拒按，甚至有神昏^证语；其反映于外则有日晡所发潮热，蒸蒸而热，濈濈汗出，不恶寒但恶热等证。同时，阳明与太阴为表里，脏腑相连，经脉相通。胃主燥，脾主湿。如果阳明病反见无汗、小便不利，则为阳明之热被太阴之湿所郁遏，邪不从燥化而从湿化，又可形成湿热病。湿热蕴郁，既不能外越以为汗，又不能下渗从小便排出，必熏蒸而迫使胆液泛溢，发生黄疸。

阳明病除腑证以外，还有经证、热证、寒证、虚证的种种证治，此反映了六经分证伤寒与杂病共论的特点，但是辨证的重点仍以腑实证为主，以体现六经纲目的主次不同。

由于阳明病的病变范围较广，证候内容亦比较复杂，故论中所列举的治疗方法也比较全面而详尽。概括起来，有汗法、有温法、有清法、有下法，但其重点仍以泻下阳明为主，设大承气、小承气和调胃承气汤为代表方。正如尤在泾所说：“盖阳明以胃实为病之正，以攻下为法之的。”

以上从生理、病理、证候特点和治疗方法等方面对阳明病作了简要的概述，使读者能够抓住重点，以对于阳明病的辨证论治有提纲挈领的作用。

问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约是也。（188）

【解析】本条以问答的形式提出阳明病三种不同的成因及证候特点，并着重论述了太阳阳明的病机。

“太阳”，指太阳表证未解；“阳明”，指胃肠干燥，大便不下。在太阳表证未解的情况下，就形成了大便干燥、秘结不下的阳明里证，即叫“太阳阳明”。由于太阳阳明多因其人素有胃燥，脾阴被燥所约，不能为胃行其津液所致，故又称本证为“脾约”。脾胃为后天之本，中央土以灌四旁。其所化生的津液不仅荣养周身，且亦滋养胃的本身，即也要“还于胃中”。胃中津液充足，胃肠得润，则大便不干。若津液不能还于胃中，则肠胃必然干燥而大便秘结不下。肠胃干燥而逼迫津液旁渗，故临床亦可见小便反多的情况。

正阳阳明者，胃家实是也。（189）

【解析】本条承上条，论述正阳阳明的病机及证候特点。

正阳阳明，指由阳明本身病变所形成的胃家实证，故又可称为“正阳阳明”。正阳阳明的形成有两种可能：其一、如成无己所说：“邪自阳明经传入府者，谓之正阳阳明”；其二、为宿食化热成燥，由燥成实而形成。总之，凡是未经太阳或少阳的传经而构成的阳明病，均为正阳阳明。

胃家实是指肠实胃满，胃肠失去了虚实交替的生理功能，故其程度既不同于一般的大便难，亦不同于脾约证的大便干，而是肠胃中有燥屎凝结成实的一种病变。

少阳阳明者，发汗，利小便已，胃中燥烦实，大便难是也。

（190）

【解析】本条承接第188条，论述少阳阳明的病机和证候特点。

文中“烦实”二字与文无关，疑为衍文，故应删掉。

少阳阳明，指由少阳病变化而形成的阳明病。少阳为半表半里，主枢机。其病当以小柴胡汤和解，切不可汗、吐、下渗利之法治。正如《医宗金鉴》所说：“少阳三禁要详明，汗^证吐下悸而惊”，李东垣又补充了禁利小便一法而成为四禁。如果医生误用发汗或利小便而耗伤津液，则必然导致肠胃不得滋润而干燥。胃中干燥，腑气不通以致大便困难，从而构成了阳明病，是谓少阳阳明。

以上三条合而观之，可见阳明病之大便难有其成因和程度的不同，三者相比较，正阳阳明为最重，太阳阳明和少阳阳明则次之。

阳明之为病，胃家实（赵本有“是”字）也。（191）

【解析】本条为辨阳明病之提纲。

仲景列六经之提纲，或以脉证论病机，或以病机推脉证。这并非体例不严格，而是使读者广开思路，避免偏见，以掌握辨证之全部。六经多举脉证为纲，唯阳明病之提纲则首先列出病机，即“胃家实”。“胃家”，包括足阳明胃和手阳明大肠，说明阳明病的病位是在胃肠之间。“实”，为阳明病的病性，即如《素问·通评虚实论》所说：“邪气盛则实”。这里的“实”，还指有实在的东西如燥屎、宿食之类。本来饮食物的代谢在胃肠之间是虚实更替的。饮食入胃，则胃实而肠虚；食物下移于肠，则肠实而胃虚。饮食物经过由上而下不断地消磨变化，最后所剩糟粕通过大便排出体外，肠胃的这种功能则概括为传化物而不藏。也就是说，饮食物在肠胃中始终处于运动变化的状态，不能堆积留滞而不动。一旦堆积留滞，就要阻塞腑气不通，以致大便不下，这是形成胃家实证的最基本的病理变化。

阳明多气多血，阳气最盛，邪气入里，易从阳化热。热伤津液，则津亏成燥。燥热与积滞糟粕相结合，则形成肠实而胃满的燥热实证，此即“胃家实”。

“胃家实”反映了阳明病的病变部位与病变性质，是对阳明病主要病机及病证的概括。但并非阳明病只此一种病情，此外，它还有热证、湿热证、瘀血证、虚寒证等。

问曰：何缘得阳明病？答曰：太阳病发汗、若下、若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳明。不更衣，内实，大便难者，此名阳明也。（192）

【解析】本条论述太阳病误治，伤亡津液而成阳明病。

太阳病发汗本为正治之法，若汗不得法，或错误地用了泻下与利小便的治疗方法，不仅其病不解，反而伤亡了津液。阳明主燥，喜润而恶燥。胃为水谷之海，亡津液者，首先伤亡肠胃的津液，以致肠胃干燥，大便不下，而转属为阳明病。转，是指病证由太阳向阳明的转变；属，是指病变已归属于阳明。“转属”与“转入”不同，“转属”为太阳之邪转而未尽，阳明里证已成，或曰“转系”，实际上是并病的意思；“转入”则为太阳之邪完全入于阳明，实际上是传经。转属阳明，意味着阳明腑实已成，燥屎结于肠胃，腑气不通，所以“不更衣”。因古人上厕所所有更衣之制，故“不更衣”即不大便的雅称。“不更衣”、“大便难”是言证候，“内实”是对病变实质的概括。由于见到以上证候即可确诊为阳明病无疑，故曰“不更衣，内实，大便难者，此名阳明也”。

问曰：阳明病，外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。（193）

【解析】本条论述阳明病的外在表现，以与太阳病相鉴别。

上条论述了阳明病的成因及其内实的见证，本条接以补充阳明病的外证。外证与表证含义不同，表证是对邪在肌表的所见脉证的概括，具体指太阳病，而外证则是里证表现于外的证候。里热外达，外证必见身热。三阳受邪虽俱见发热，但热型各有不同。太阳病为邪伤荣卫，阳郁于体表，故见“翕翕发热”；少阳病为邪在半表半里，正邪分争，故见“往来寒热”；而阳明病则为邪结于里，热由里向外腾达，故表现为“蒸蒸发热”，即像炊笼之热气腾腾。若以手扪患者皮肤之热比较：太阳病初扪尚觉灼手，但扪之时久则热度渐逊；而阳明病之热则不然，扪之愈久则热感愈甚，以此可作临床鉴别。阳明里热外蒸，逼迫津液外泄，必见汗出，故汗出亦为阳明外证之一。六经为病见汗出者，非仅阳

明一经。太阳病中风证有自汗^{𦛳𦛳}；少阳病有合目汗出；少阴病亦有因阳虚不能固表的自汗出等等，但均不及阳明病汗出为甚。阳明病由于里热炽盛，不断地向外发越透达，迫使津液大量外泄，而表现为汗出连绵不断，所谓“阳明病，法多汗”其理即在于此。阳明病的汗出虽有一定的散热作用，但其热并不因汗出而退，这又与太阳表证之热随汗而解不同。“不恶寒，反恶热”是阳明病与太阳病以及少阳病的主要鉴别点。病在太阳，发热与恶风寒同时并见；邪在少阳，正邪交争于半表半里，故寒热往来；而阳明则由于热结于里，里热外达，表里俱热，故不恶寒而反恶热。

问曰：病有得之一日，不发热而恶寒者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。（194）

【解析】本条论述阳明病初起见恶寒的缘由，以及转属阳明之里的辨证要点。

据上条所述，阳明外证本应见身热、汗自出、不恶寒、反恶热。而今“病有得之一日”，即阳明初起，却见不发热而恶寒。这说明疾病的变化是复杂的，其临床表现既有普遍规律，也有特殊性。据本论所载，阳明病而见恶寒证的有两种情况：一是由于阳明内热蒸腾，大汗出使腠理开泄，卫表不固而见背微恶寒者；另一种情况即本条所述，在阳明病初起阶段，亦即经表之邪欲往阳明传变，而又未完全入里之时，由于经表仍有邪气，故亦见恶寒。但由于阳明里热业已开始形成，故这种恶寒的时间不长，很快就将自行解除，而出现身热、自汗出、不恶寒反恶热等阳明病的典型证候。

问曰：恶寒何故自罢？答曰：阳明居中，土也，万物所归，无所复传。始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。（195）

【解析】本条接上条论述恶寒自罢的机理，以揭示阳明病有经腑之不同。

恶寒为什么自行解除，张仲景以五行学说解释了病变机理。阳明胃居于中焦，按五行属性，归类属土，这就是“阳明居中，土也”的意思。阳明胃是五脏六腑之大会，为水谷之海，营卫气血生化之源，其性能就如五行的土一样，既能长养万物，也是万物之归宿，故曰“万物所归”，这主要是从生理方面来讲的。若就病理而言，邪传阳明，形成燥热结实，燥屎留而不去，此即所谓“无所复传”。也就是说，胃家之实别无去路，但又不是说凡阳明病邪都不传变。如阳明经证，其邪在浅表且呈弥散状态，故仍有可传变之机。就是腑实证，由于燥热不去，灼伤真阴，亦可累及少阴而竭其液。所以，阳明病无所复传仅仅说明有形之邪在胃

腑凝结的时间较长，有六七日、八九日，甚至直到津液亏耗、正气受伤，生命垂危之时仍为阳明胃腑之燥热实证。

正因为阳明病有经、腑之不同，所以在阳明初得病时，邪气在经，阳郁不伸，温煦失职，而可见到恶寒，待邪气入腑，从阳化热，里热外发，则恶寒自止而转见汗出恶热之证。这种“始虽恶寒，二日自止”的证情，正反映了阳明病的特点，据此即可确立诊断，故曰：“此为阳明病也”。

本太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。（196）

【解析】本条论述太阳病汗出不彻而转属阳明。

太阳表证，本应发汗，但发汗要得法，既不能过汗而伤亡津液，又不能发汗太少而不足以去邪。本条虽然用了发汗之法，但是“汗先出不彻”，即汗出不彻底。“彻”者，透也，尽也。汗出不透，则表闭不开，阳郁不宣，邪不能除，随即化热，内传于里而转属阳明。本条与第192条虽均是太阳转属阳明，但他们所形成的证候却不尽相同。前条因汗、下、利小便伤亡津液而转属阳明，多以腑实证为主，故见内实，不更衣，大便难等证。本条不伤津液而转属阳明者，乃为太阳之邪传于阳明之经，或化为弥漫之热，因而无内实的表现。此外，还有一种意见认为：伤津液者是针对正气而言，不伤津液者针对邪气而论。说明不仅正气受伤太阳之邪可转属阳明，而且邪气盛实亦可由太阳病转属为阳明病。从两条的异同比较中，以见内因与外因、正气与邪气的辩证关系，揭示了太阳之邪转属阳明的两个因素。此说亦可供参考。

伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濇濇然者，是转属阳明也。（197）

【解析】本条论述伤寒转属阳明的见证。

“伤寒发热无汗”，言寒邪客于太阳，表闭阳郁；“呕不能食”，是里气不和，胃气上逆之证，或来自表邪之影响，或是表邪内传少阳。因少阳病常见喜呕、不欲食等证。若由无汗而转见“反汗出濇濇然”，说明病变既不在太阳，也不在少阳，而是转属阳明了。因为只有阳明里热蒸腾、腠理开泄，才会使汗出连绵不断。故“汗出濇濇然”可以说是转属阳明的主要标志，当是辨证的关键。“汗出濇濇然”之前用一“反”字，是对前“无汗”而言的，在这里既有加强辨证的作用，也突出了病机的转折。用意深刻，耐人寻味。

伤寒三日，阳明脉大。（198）

【解析】本条论述阳明主脉，并借以反映病机。

“伤寒”，泛指外感疾病。“三日”，言受邪发病已有几天，按照传变规律应该病及阳明。但是否传至阳明，要以脉证为据，正如张仲景所说：“伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也”，“……颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也”。伤寒三日，脉由浮转大，说明病有传变征象。“脉大”，是言脉形宽阔洪大，其势如波涛汹涌。阳明为水谷之海，多气多血，阳气最盛，病入阳明，正邪斗争有力，正盛邪实，阳热亢盛，气血鼓动于外，故脉应之而大。但由于病程短，邪陷时间不长，仍在阳明气分，而未与糟粕凝结，故仅为弥散之热而尚未敛结成实，故只能见到洪大之脉，而不能见到实脉。洪大脉与实脉不同，李濒湖作了比较：“洪脉来时拍拍然，去衰来盛似波澜。欲知实脉参差处，举按弦长怫怫坚”。说明洪脉是浮取有力，脉形宽大；而实脉则是举按皆有力，脉形弦长。

以上从第188条到198条，可看为阳明病的总论。从中可以看出：阳明病有经证腑证之分，亦有虚实寒热之别。只有把这几方面的问题搞清楚了，才能掌握阴阳两纲的辨证。从这里我们也可以看出，《伤寒论》的六经是始终贯穿了八纲辨证精神的。以下则介绍阳明病各类证候的辨证与治疗。

伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄；若小便自利者，不能发黄。至七八日大便鞕者，为阳明病也。

（199）

【解析】本条论述太阳与太阴、太阳与阳明的脉证鉴别，说明阴阳病证有出入转化的机制。

伤寒当见脉浮而紧，乃为太阳表实证之正脉。若见“脉浮而缓”，即脉由紧变缓，说明太阳之寒邪已经化热，如同第40条“伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，有少阴证者，大青龙汤发之”的病机一样，表邪化热则脉变缓而有入里之机。入里又有阴阳之别，入阳明少阳者为阳也；入少阴太阴者为阴也。入何经都有其特殊的证候表现，是为辨证之根据。如果见有口苦、咽干、目眩、心烦喜呕、嘿嘿不欲饮食为传于少阳；如见有脉微细、但欲寐则为传于少阴；如见有一身手足尽热、烦躁、汗出而渴的为转入阳明。今见手足自温而身不发热，又手足不厥冷的，则知是脾经有热的表现，故谓“系在太阴”。系者，联系的意思。这里讲的是太阳之邪化热入里而联系于太阴。

太阴为阴土主湿。若脾经热邪影响运化水湿的功能，则热与湿合，湿热蕴郁熏蒸，“身当发黄”。言外之意，必见无汗、小便不利等证。如果小便自利，说明湿有出路，故“不能发黄”。若湿去热留，至七八日，

太阴之热不解，外出阳明，从燥化而见大便硬者，则是太阴转出阳明，形成了胃家实证，故“为阳明病也”。本条寓意非常深刻，它反映了阴阳表里病证在其发展过程中，依据一定条件可以相互转化，表证可以入里，里证可以出表；阳病可以转阴，阴病亦可以转阳，这种相互转化的规律，在六经病中具有普遍意义。

伤寒转系阳明者，其人濇然微汗出也。（200）

【解析】本条承上条续论邪传阳明的见证。

上条讲到太阴之热外出阳明，有小便自利、大便因硬的表现。本条所论，由太阳之表转系阳明之里，当有濇然微汗出的见证。虽两条所论之传入途径不同，但是，无论由太阳转系阳明，还是由太阴外出阳明，只要是属阳明病，就必然有其共同的证候。因此，两条所见之证，应相互联系，相互补充。阳明病濇然汗出之理，前已作过分析，这里不赘述。由于本证是邪气初入阳明，热势不甚，故虽亦是汗出连绵，但量并不多，即所谓“濇然微汗出也”。

阳明中风，口苦咽干，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧；若下之，则腹满、小便难也。（201）

【解析】本条论述阳明经腑同病时，不能下之太早的道理。

阳明中风乃为阳邪所伤，而与伤寒不同。阳邪伤人则易于化热而见阳明经腑同病。阳明在经之邪不解，故见发热恶寒，脉浮而紧。这里需要指出的是：阳明之脉浮紧与太阳之脉浮紧不同。太阳脉浮主表、紧为寒，即风寒伤于体表的脉象；而阳明脉浮表示在经之邪不解，紧主里实，即阳明经腑俱病之脉，故其人必大便秘结。阳明经腑俱病，应先解其表，后攻其里，或者表里两解。倘若以其有腹满微喘、大便秘结之里证，而忽视寒热脉浮之表证，急不可待地先用泻下之法，则为下之太早。下之太早，则使在经之邪乘机内陷聚集于里，而使病情加重。热更盛，里益实，故腹满不解；热盛津伤，则小便难。

有的注家认为本条是三阳合病，即发热恶寒，脉浮紧为太阳病；口苦咽干为少阳病；腹满微喘为阳明病。虽对病证的解释有所不同，但对不能过早使用下法的认识还是一致的。

发汗与泻下是两种不同的治法。病在太阳之表宜汗；病在阳明之里宜下。前人谓：伤寒下不厌迟，汗不厌早，是根据伤寒病的特点总结出来的经验之谈。说明及时解除表邪，使之不至于内传故要早发汗，而当有表邪存在时，或里犹未成实，则又不宜早下，以防引邪入里或伤害脾胃之阳而生他变。

阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒。（202）

【解析】本条以能食与不能食辨阳明之寒热证候。

胃为消化系统的重要器官，主受纳与腐熟水谷。因此，胃有寒热则必然反映到饮食方面来。阳明中风，风为阳热之邪，热则消谷，故“能食”；若中寒，寒为阴邪，易伤胃中阳气，胃阳受伤则不能腐熟水谷，故“不能食”。

阳明病的来路有二：一为传经之邪，一为本经受邪。一般认为，传经之邪多为化热之后而传于阳明；本经受邪则不然，可受于热，亦可中于寒。本条以饮食情况来辨寒热，主要是针对阳明自身受邪而言。然而，辨证的指导思想应该是：“外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”因此，无论是传经还是自受，归根到底是与人体胃气的盛衰有关。

阳明病，若中寒，不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕，必大便初硬后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。（203）

【解析】本条论述阳明中寒以致胃中冷的证候。

阳明中寒，胃中必冷，腐熟无权，故不能食。然阳明胃与太阴脾以膜相连，同居于中焦，病变常相互影响。胃寒及脾，脾运失职，水谷不别，清浊不分，则见小便不利，大便溏泄而水谷夹杂。由于胃中冷，寒气凝结，则又见大便初硬后溏而“欲作固瘕”。“固瘕”为证候名，形容大便初硬后溏，说明固瘕乃假象。初硬后溏，反映了阳虚不能化的特点，与阳明的燥热实证有本质区别。阳明主四肢，四肢为诸阳之本，胃阳虚不达四末以敛摄津液，故手足渗出冷汗而濇濇然，此与阳明胃肠燥热逼迫津液外渗的手足濇然出热汗截然不同。“以胃中冷，水谷不别故也”，是对小便不利、大便初硬后溏等证的病机概括，指出以上诸证，皆因脾胃虚寒，腐熟运化无权所致。

阳明病，欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濇然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。（204）

【解析】本条承接上条，论述阳明病中寒，胃气得复，病愈作解的见证。

阳明病中寒，本不能食。今欲食者，说明寒去而胃阳得复。若阳复太过而从燥化，则小便数多而大便当硬，今小便反不利而大便自调，说明湿热内蕴而未成燥实。湿留关节，筋脉不利，故骨节疼痛；湿热郁蒸，则“翕翕如有热状”。由于胃阳得复，正气充盛，能以驱邪外出，湿

热邪气得以外越，其人则可忽然见狂躁、濈然汗出而病愈。“此水不胜谷气”，是张仲景对本病自愈机理的概括说明。阴不胜阳，有胃气为盾，故其病向愈。

关于“脉紧则愈”有所争议。有的认为：紧言脉象有力，是邪去正复的标志，故脉紧则愈；也有的认为：寒邪为病，多见紧脉，今胃阳来复，阳能胜阴，故当为“脉紧去则愈”；还有的认为：脉者，血脉也，因阳气得复，血脉紧固而外邪不入，故病愈等等，尽管诸家见解有所不同，但就其正胜邪却这一点来讲，则是完全一致的。成无己的“阴阳气平，两无偏胜则愈”的注解，确是说出了病愈的根本。

阳明病欲解时，从申至戌上。（205）

【解析】此条论述阳明病欲解的时辰。

凡六经之气均有旺时，其旺时与自然界六气旺时相应。阳明胃属燥金，金气旺盛之时，在于申、酉两个时辰。如果阳明病经过治疗之后，已具备了作解的条件，则当此时此刻，人体正气可借助于自然界的旺气而有利于疾病的作解，这种生物学的特定机能现已被人们所重视。

阳明病，不能食，攻其热必哕。所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，故攻其热必哕。（206）

【解析】本条承第203条，论述胃中虚冷反攻其热所产生的不良后果。

阳明病不能食，本为胃中有寒所致。若误认“固瘕”之手足濈然汗出，大便初硬后溏而为胃家实热，用苦寒药攻之，则必使中气更虚，胃寒益甚。胃寒气逆则发生呃忒之变，即所谓“攻其热必哕”。“所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，故攻其热必哕”，为自注句。说明产生哕证的原因不外有两方面的因素：一方面是胃中虚冷，属于内因；另一方面是外受寒邪或治以寒凉药物，内外合邪，使寒者更寒，胃气上逆，则成哕逆。

阳明病脉迟，食难用饱，饱则微烦，头眩，必小便难，此欲作谷疸，虽下之，腹满如故。所以然者，脉迟故也。（207）

【解析】本条论述寒湿郁滞欲作谷疸的脉证及治疗禁忌，以见阳明与太阴的表里关系。

阳明病脉迟，迟主寒，为阳明中寒之象。一般来讲，阳明中寒本不能食。此虽能食，但不能饱食，即所谓“食难用饱”，说明胃气虚寒，腐熟无权。若不明此理，而强求饱食，则虚弱的胃气被谷气所羁縻，胃气郁遏，水谷不能化成精微物质而反生湿邪。寒湿凝滞，影响气机升降，

胃脘气郁，则微微发烦；清阳不能上荣头目，则头眩；下焦之气不行，水道不通，必小便难。寒湿郁滞不化，自可发生黄疸之变，故谓“此欲作谷疸”。欲作，是将作而未作之意。据《金匮要略方论》所云：谷疸生于脾胃，因于“风寒相搏……谷气不消，胃中苦浊，浊气下流”所致。发黄有多种原因，但因湿邪蕴郁而发者，不外两种：一是湿热熏蒸而发的，为阳黄；一是寒湿郁滞而发的，属阴黄。据上述脉证，此之谷疸当属阴黄。寒湿发黄，应治以温中渗利化湿之法。若因其微烦或有腹满等证，而妄用苦寒泻下，则不仅不能祛邪，反更伤脾胃，使寒湿郁滞更甚，故曰“虽下之，腹满如故”。从“腹满如故”可知，前证本有腹满，下后腹满不仅不减，反而更加严重。那么，为什么欲作谷疸的腹满不能用泻下？其原因就在于本证属脾胃气虚而有寒湿凝郁。“所以然者，脉迟故也”，不仅言其脉象，更重要的是以脉象概括病机，借以申明寒湿发黄不可下的道理。

阳明病法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。
(208)

【解析】本条以有汗与无汗辨阳明病之虚实。

阳明病，一般地指肠胃燥热实证。胃为水谷之海，是津液化生之源。阳明热盛，蒸腾津液外越，必见濈濈汗出，或大汗出，故汗出被列为阳明病的重要外证之一。三阳为病，均有发热、汗出，但各有各的特点。太阳病见汗出者，为中风表虚证；无汗者，为伤寒表实证。阳明病“法多汗”，是讲阳明热实证的一般规律是多汗的，而今无汗，故曰“反”。阳明病无汗，常见于以下两种情况，一是湿热蕴郁，不能泄越，而致发黄的，可见无汗或仅头汗出而身无汗；二即本条所述，因阳明气虚，水谷无以化生津液，则无以作汗。因虚不仅无汗，同时还有“身如虫行皮中状”之感。“皮中”，即皮下之肌肉部分。阳明之气主肌肉，阳明气虚，气血不足，不能作汗透出肌表，故皮中有如虫子爬行的感觉。因为中气虚并非短期形成，故曰“此以久虚故也”。

阳明病，反无汗，而小便利，二三日，呕而咳，手足厥者，必苦头痛；若不咳不呕，手足不厥者，头不痛。(209)

【解析】本条承上条，进一步论述阳明虚寒而又挟寒饮上犯的证候。

阳明病法多汗，而反无汗者，则非虚即湿。今小便利，说明三焦水道通利，可知本证非湿郁之患，而属阳明虚寒。阳明虚寒，腐熟无权，则易生水饮。二三日以后，寒饮上犯，使胃气上逆则作呕；使肺气不降则作咳；上蒙清阳则头痛；胃气虚寒，不能充养四末则手足厥冷。言外

之义，以其胃气虚寒，消磨水谷的机能减退，还应有不能食等证。然而阳明胃气，毕竟还没有一蹶不振，所以阳明气旺以致足以抑制寒饮邪气时，则就不呕、不咳，手足不厥，头也不痛。关于本证的治疗，仲景未出治法与方药，后世很多注家加以发挥，提出了不少治疗方法，有主张用小青龙汤散饮的；也有主张用葛根汤发汗散寒的；还有主张用小建中汤温中扶虚的。根据本证的证候及病机特点，若治以吴茱萸汤温胃阳、散寒饮、降浊逆，可能比以上诸方较为适宜。

阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人必咽痛；若不咳者，咽不痛。（210）

【解析】本条论述阳明病阳热挟风上扰的证候，以与上条作对比鉴别。

足阳明胃脉之支，从大迎前下人迎，循喉咙。手太阴肺经起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺至喉部。可见肺与胃以经脉相连，关系非常密切。若阳明内有邪热，热邪上迫于肺，肺失清肃则咳，热邪循经上咽喉，则咽喉作痛。前者阳明有寒，则寒邪动饮上犯清阳而苦头痛；今者阳明有热，则热多动风，风热上扰，故头目眩晕。阳明热盛于内而蒸腾于外，故不恶寒。阳明热盛，能消磨水谷，故能食。

本条实为阳明热证的补充，与上条互相比，从病因病机来讲，一为虚寒挟饮上犯，一为实热挟风上扰；从症状表现来看，一为不能食，一为能食，一为手足厥冷，一为不恶寒，一为苦头痛，一为但头眩。两相对比，以加强辨证思维。

阳明病无汗，小便不利，心中懊_怱者，身必发黄。（211）

【解析】本条论述湿热发黄的成因及先期症状。

阳明病无汗，或因于虚寒，或因于湿郁。本条所论乃阳明之热被湿邪所郁遏，湿热纠缠，难解难分，热不得越，湿不得泄，故身无汗；或即使是有汗，也只是头汗出，剂颈而还，余处无汗。湿热蕴郁于里，三焦水道不通，故小便不利。湿热蕴郁内扰，故心中懊_怱而烦郁特甚，若湿热不解，蕴郁熏蒸，影响胆液的正常排泄，则身必发黄。湿热发黄之因，在于湿热交阻而不能泄越，故这里的“无汗，小便不利”既是证候，又足以说明病因病机。心中懊_怱是湿热蕴郁不能泄越的必见证，故亦常是湿热发黄的前驱证候。心中懊_怱还可见于虚烦、结胸、阳明腑实等证，但总由热郁所致。本证乃湿热交结，热欲外发，但又被湿郁而不得发泄，故其人烦郁特甚而有无可奈何之感。

阳明病，被火，额上微汗出，小便不利者，必发黄。（212）

【解析】本条论述阳明病误治而续发黄疸的见证。

三阳病均有发热，但热型不同。一般说来，阳明之发热当为蒸蒸而热，伴随着濈濈汗出。但也有发热而不汗出者，此即湿热蕴结之证。若不明此理，误把阳明湿热认作表热而以火劫汗。火气虽微，内攻有力，因而使阳明之热更甚。然阳明之热的发展有两种机转，一为热从燥化，即热迫津液外泄，汗出津伤，胃中干燥，大便成硬，形成阳明腑实证；另一种是热与湿合而变为湿热证。今阳明之热虽盛，但被湿邪所郁遏，不能外越而为汗，故周身无汗，仅是额头出一点汗，而且小便为之不利。于是则热不得越，湿不得泄，湿热相蒸，故身必发黄。

阳明病，脉浮而紧者，必潮热，发作有时。但浮者，必盗汗出。（213）

【解析】本条论述阳明经病及经腑同病的脉证。

阳明病，见脉浮为在经之邪不解，邪未完全入里，紧主里实。故阳明病之脉浮而紧为经腑同病，与太阳之脉浮紧所主的病证不同。潮热者，如潮之信，到时即发，故曰“发作有时”，是阳明里热实证的典型症状之一。脉证合参，说明证属阳明经腑同病，并且以里实腑证为重。若脉但浮而不紧，表明邪只在经，还尚未传于肠胃阳明之腑。寐则阳入于阴，卫表不固，在经之邪热逼迫津液外泄，故睡中汗出即“盗汗出”。正如成无己所说：“阳明病里热者自汗，表热者盗汗”。说明阳明病多汗，是里热蒸腾之故，若热不在里而在于经表，其部位较浅，故不为自汗而为盗汗。

本条应与第201条互参。皆论经腑同病不可下之太早。

以上诸条，从汗的有无以及汗出的形式等方面，分析论证了阳明病的寒、热、虚、实，在经、在腑的辨证要点。文字虽简，但内容全面而详尽，具有深刻的辨证意义，学者应细心加以体会。

阳明病，口燥，但欲漱水不欲咽者，此必衄。（214）

【解析】本条论述阳明经热致衄的机理与见证。

阳明病，如果里有热，热邪蒸腾，津液受伤，胃中干燥，必大渴欲饮水数升，是为白虎加人参汤证。今里无热而但经中有热，阳明经起于鼻之交頄中，下循鼻外，入上齿中，还出挟口，环唇，故经有热，则口齿干燥，“但欲漱水不欲咽”。阳明经热不解，迫血妄行则衄。成无己指出：“阳明里热，则渴欲饮水，此口燥但欲漱水不欲咽者，是热在经

而里无热也。阳明气血俱多，经中热甚，迫血妄行，必作衄也。”他讲的很有道理。也有的注家认为：腑热为气分之热，所以大渴引饮；经热在血脉，为血分之热，热在阴分而局限，故虽口燥，却不渴饮。此说亦可参考。

阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此大便必鞣故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便鞣。当问其小便，日几行。若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出；今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。（215）

【解析】本条论述以小便多少判断大便是否成硬。

阳明病本有发热，汗自出的外证，医生误以发热、汗出为太阳表病，而“更重发汗”。发汗后可能暂时汗出减少，发热亦随之减轻，医生以为“病已差”。其实不然，发热、汗出虽有减轻，但因发汗更伤津液，以致胃中干燥；邪热入里，又出现心烦不了了之证，故病犹未瘥。津伤胃燥则大便必硬，“以亡津液，胃中干燥，故令大便鞣”，是对误治津伤化燥的自注之词。由于二便相关，故此时应当问其小便情况。如果小便素日三四次，“今日再行”，即每天小便两次，则可断定“大便不久出”。其道理是小便由三四次减为二次，说明津液能够还于胃中，而不偏渗膀胱，则肠胃有津液以润，“故知不久必大便也”。

对于上述胃燥津伤的大便硬，一般均不宜用攻下之法，可待其津液自复，还入胃中，使津液自和而大便自下，或用润导之法以导便外出。此与阳明热结之大便硬，在治疗方法上不同。

伤寒呕多，虽有阳明证不可攻之。（216）

【解析】本条论述阳明病禁下证，以见阳明病有可下与不可下之辨。

阳明病虚证、寒证或有经证不解时不可攻下，已如前述。本条提出“伤寒呕多”不可攻之，也是阳明禁下之一。呕多不可攻的原因有二：一、呕多，即以呕为主，是胃气上逆的反映，病变在于上，故禁用承气汤攻下。正如成无己所说：“呕者，热在上焦，未全入府，故不可下”。二、呕为少阳之主证，若阳明病兼有少阳枢机不利时，亦可见呕多。由于少阳病禁下，故虽有阳明证，亦不可攻。总而言之，无论从病位上讲，还是从病机上讲，凡见呕多者，均不可攻下。否则，必引邪内陷，以致后患无穷。

阳明病，心下鞣满者，不可攻之。攻之，利遂不止者死，利止者愈。（217）

【解析】本条承上条，进一步论述阳明病禁下证及误下的变证与预后。

阳明病，若属腑实可下证，当见腹满疼痛拒按。今见心下硬满，未言疼痛拒按，说明邪结偏上，尚未构成实证。此证之硬满，乃气机痞塞所致，故曰“不可攻之”。若误用攻下，必损伤脾胃之气，脾气不升则下利，病及少阴，肾关不固，则利遂不止，反映了脾肾气败，故为死证。如果攻下之后，虽有下利，但能自止，说明脾气未败，尚有自复之机，故曰：“利止者愈”。

阳明病，面合赤色，不可攻之，必发热色黄，小便不利也。

（218）

【解析】本条论述阳明经证不可下及下后发黄的变证。

阳明之经脉布于面，面合赤色为阳热郁于阳明经而不得宣泄的反映。经者表也，邪在阳明经表，里未成实，故“不可攻之”。即或阳明经腑同病，亦须先解经邪而后攻下。若经邪不解，贸然攻下，必虚其脾胃之气，脾虚不运则生湿，经中邪热乘虚入里，与湿邪相合，湿热熏蒸，则发热身黄；影响三焦水道之疏通，湿邪不能下泄，则小便不利。

以上三条，总论阳明之不可下证，若与第201条和206条合参，可见阳明病之不可攻下当包括以下几方面：一、阳明虚证不可攻；二、阳明寒证不可攻；三、阳明湿热证不可攻；四、阳明经证不可攻；五、阳明病位高而邪结偏上者不可攻；六、阳明病位浅而邪结不深者不可攻。若不当攻下而强攻之，必虚其虚，而致正虚邪入，则后患无穷。因此，掌握不可攻下之禁，事关重要。

阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。（219）

【解析】本条论述阳明病胃不和的证治。

接前述阳明病的不可下证之后，此又论其可下之证，则充分体现了禁下与可下的辩证思想。可下之证，意味着阳明燥实已成。但可下也要分清病位深浅和燥结的程度轻重，若病位深，病势重，燥结成实者，则可用大承气汤；若病位深，病势轻，燥热成硬者，可用小承气汤；若病位浅，病势轻，燥热只结在胃的，则用调胃承气汤。仲景本着由上到下，由浅入深，由轻到重的病变层次，故首先举出调胃承气汤证。

对本条的解释一直有争议，焦点在于“不吐不下”四字。最早注解《伤寒论》的成无己认为：“吐后心烦，谓之内烦；下后心烦，谓之虚烦。今阳明病不吐不下心烦，则是胃有郁热也，与调胃承气汤，以下郁热”。后世多数注家均依成氏的见解，把“不吐不下”作为治疗过程来

看。但也有少数注家把“不吐不下”看做是患者的临床症状，即其人既不吐，又不泻。结合临床实际，再细推敲文意，后者的解释亦是有道理的。因心烦常在多种病证中见到，吐而心烦者，属少阳；不吐不下而心烦者，属阳明胃燥，因此“不吐不下”就有鉴别诊断的意义。若将这两种意见结合起来，则更加全面，即未经吐下而见不大便、心烦等证，说明非属栀子豉汤证的虚烦，而属于阳明胃家热实的实烦；又因不见腹痛拒按，日晡所发潮热，漉漉汗出等大肠燥实证，故不用大承气汤，而用调胃承气汤以和胃燥，胃中燥热得解，则心烦自止。

调胃承气汤方义，在第30条已述及。因本方泻下之力较缓，以缓下之法而使胃气调和，故名曰“调胃”。承者，顺也，有承继、接续之意。“气”，指肠胃之气。因为承气类泻下之药，可使胃肠之气承之以下，故取名“承气”。调胃承气汤的服法有二：一是“少少温服”，多用于和胃，如第30条；一是顿服，主要用于燥热内结，临床应视证情而选用适当的服药方法。

阳明病脉迟，虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足漉然而汗出者，此大便已鞅也，大承气汤主之；若汗多微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤；若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令大泄下。

（220）

大承气汤方：

大黄四两，酒洗 厚朴半斤，炙，去皮 枳实五枚，炙 芒硝三合

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，煮取二升，去滓，内芒硝，更上微火一两沸，分温再服。得下，余勿服。

小承气汤方：

大黄四两 厚朴二两，炙，去皮 枳实三枚，大者，炙

已上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。初服汤，当更衣，不尔者，尽饮之；若更衣者，勿服之。

【解析】本条论述大、小承气汤的证候鉴别以及承气汤的使用禁

忌。

“阳明病脉迟”，多见于阳明中寒，因寒主凝滞，脉道不利所致。如第207条“阳明病脉迟，食难用饱，饱则微烦，头眩，必小便难，此欲作谷疸，虽下之，腹满如故”。此证多属虚寒，故脉当迟而无力。至于第246条提到的“阳明病脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤”。这里的“脉迟”，则含有脉缓的意思。而本条所述之“脉迟”，是因肠胃结实，腑气不通，影响气机不利，血脉不畅所致，故脉迟而必有力。文中“虽汗出”的“虽”字，有的注家认为当放在“脉迟”之前，意思是说，阳明病本当见沉紧之脉，此虽脉迟，但迟而有力，且有汗出、不恶寒等里热的见证，故断为阳明腑实证无疑。阳明里实热盛，壅滞于内外，阳气不得流通，故身重。肠实胃满，腑气不通，气机不利，邪热上迫，壅塞于肺，故短气腹满而喘。阳明之气，旺于申酉二时，若见有日晡潮热者，说明经表之邪已入于里，腑实确已形成，故曰“可攻里也”。在上述证候的基础上，又见手足濇然汗出，则是大便已硬、燥屎内结的象征。因为手足为胃所主，阳明病，实热聚于胃，不能散发于外，势必迫津液旁走四肢，而见手足汗出连绵不断。阳明病见不大便、腹满疼痛、潮热、手足濇然汗出、脉迟有力，说明痞、满、燥、实诸证已经具备，大便业已成燥，故以大承气汤攻下。

倘若是其人汗出虽多，但其热不潮，同时又有恶寒之证，说明不仅阳明腑实未成，而且表证也尚未解，故不可用承气汤攻下。

若潮热而不见濇然汗出，或汗出而不见潮热，二者仅见其一，同时又见“腹大满不通”，“大满”，形容胀满之甚；“不通”，指大便不下，这说明肠中糟粕初结，燥实不甚，以痞满为主，故不能用大承气汤峻下，而只可与小承气汤缓下。

大承气汤用厚朴之苦温，行气以消满；枳实之苦寒，下气以消痞。二药均为气分药，可通达肠胃之气。又用芒硝之咸寒以软坚、开热邪之凝结；大黄之苦寒以泻下热结。硝黄二药在枳实、厚朴的推动下，而有荡涤肠胃、推陈致新的作用。四药相辅相成，配伍得当，用治阳明腑实痞满燥实俱备，效如桴鼓。因本方可泄热破结，化燥软坚，顺理腑气，攻下燥屎，力大而峻，故名“大承气汤”。

临床使用本方，应注意其煎药法：当先煮枳实、厚朴，以行气于前；后煎大黄，以泄热结；最后入芒硝，以软坚化燥。从而可达到荡涤肠胃、推陈致新的目的。

使用本方，除应见潮热、汗出，特别是手足濇然汗出这两个典型症状外，还一定要参以腹诊、舌诊和脉诊。若见腹如合瓦，胀满疼痛拒

按，舌苔黄燥，甚至有芒刺，脉沉迟而有力的，才可用本方泻下。服大承气汤以后，如大便已下，还要再检查腹部的情况，尤其是脐周围的情况。若大便虽下，但量不多，脐周依旧硬满疼痛，乃为燥屎未尽，可再服药；若大便泻下较多，腹部已不痛不硬，为燥屎已尽，则当停药。

小承气汤用大黄泻下阳明热结，用厚朴行气消满，枳实理气消痞。厚朴、枳实协同行气导滞，以助大黄的泻下作用。因本方大黄倍厚朴，是以气药为臣，与厚朴倍大黄的气药为君之大承气汤有别，故泻下之力较大承气汤为缓，而名“小承气汤”。另外本方朴、枳、黄三药同煎，不分先后次第，则大黄泻下之力变缓。同是大黄一药，因煎法不同，其泻下则有缓急之分，临床使用时应当注意。

张仲景在上条论述了调胃承气汤证，随之在本条又列出了小承气汤、大承气汤证，以资互相鉴别。调胃承气汤治燥热在胃，证以燥热为主，故以甘草缓恋硝、黄于上，以使胃气调和，且有护正之义，而为和下之法；小承气汤治大便成硬在肠，腑气不顺，证以腹部痞满为主，但未到燥屎内结，肠气闭阻的程度，故只用朴、实、黄而不用芒硝，与大承气汤相较，则为和下之法；大承气汤治燥屎凝结在肠，腑气闭阻，证则痞、满、燥、实俱备，故方中行气、软坚、泻下并用，以荡涤肠中燥屎，为峻下之法。这就是三个承气汤的不同之处，也是临证区别使用的主要依据。

阳明病，潮热，大便微鞣者，可与大承气汤；不鞣者，不与之。若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转失气者，此有燥屎，乃可攻之；若不转失气者，此但初头鞣，后必溏，不可攻之，攻之，必胀满不能食也。欲饮水者，与水则哕。其后发热者，必大便复鞣而少也，以小承气汤和之。不转失气者，慎不可攻也。（221）

【解析】本条论述燥屎已成未成、可下不可下的辨证，以及大小承气汤的使用方法。

据上条所述，大承气汤证的典型证候是潮热，手足濇然汗出，大便干硬不下，腹满疼痛等，诸证俱备，则反映燥屎已成。本条证见“大便微鞣”，即腑实已结，但同时伴见“潮热”，则标志燥屎已经形成，故可与大承气汤治疗而不为错。若虽有潮热，但屎不硬，则自然不能用大承气汤攻下。若其人已有六七日不大便，理应考虑是否有燥屎的问题，即所谓“恐有燥屎”，但其人并未呈现潮热、手足濇然汗出、腹满疼痛等大承气汤证的典型证候，此时如何判断燥屎的形成，“欲知之法”，可先少与小承气汤。服汤后，若大便未下而转失气（指放屁）的，说明必有

燥屎凝结、肠气闭阻，而少量的小承气汤尚不足以荡涤其实，只能使燥屎略有活动而转气下趋。由此可知，燥屎已成，可放心使用大承气汤攻之。若服小承气汤后并没有转失气，说明其证或属燥屎未成，或属肠胃虚寒、大便初硬后溏的“固瘕”证，然均不可用大承气汤攻下。若攻之，则虚以实治，必伤脾胃阳气。一旦中阳被伤，腐熟运化水谷的机能减退，则必腹胀满而不能食。水性阴寒，而能郁遏胃阳，故当中阳不足之时，饮水后每多见气逆作哕之证。“其后发热者”至“以小承气汤和之”一段，应接在“此有燥屎也，乃可攻之”之后。言用大承气汤后，又见发热的，是阳明之实热复结，热灼津液，故“必大便复鞕而少”。因已用过大大承气汤峻下，虽有实热复结，但其势已缓，仅表现为发热而不见潮热；仅见大便硬而少，非为燥屎不下，故不能再用大承气汤峻下，而用小承气汤缓下和胃即可。最后“不转失气者，慎不可攻”一句，是复申禁诫之词，强调燥屎未成，则千万不可以大承气汤贸然攻下。

根据临床观察，肠中有燥屎，不一定先要用小承气汤测试，有的患者，不服攻下药物亦可见转失气。而凡大便不下，间有转失气味极臭者，即为可下之证，用大承气汤多能取效。

夫实则谵语，虚则郑声。郑声重语也。（222）

【解析】本条以患者的语声辨病之虚实。

“夫实则谵语，虚则郑声”，“夫”是发语词，“虚”与“实”是对正邪而言，即所谓“邪气盛则实，精气夺则虚”。谵语和郑声都是意识不清情况下的胡言乱语。谵语者，表现为声高气粗，语无伦次，多由于邪热盛实，扰于心神所致，其证属实，故曰“实则谵语”。郑声，“郑”有郑重、严肃之意，其特点是语声低微，频繁重复而郑重其事，如《证治要诀》所说：“郑重频繁，语虽谬而谆谆重复不自己”。因其频繁重复，故谓“重语”，多由精气亏虚，心神失养所致，故曰“虚则郑声”。谵语、郑声不仅见于外感病，亦可见于内伤杂病。外感病见谵语，多属阳明实热，见郑声多为病及少阴。

直视谵语，喘满者死。下利者亦死。（223）

【解析】本条论述阳明燥热伤及五脏所导致的死证。

阳明居于中焦，中央土以灌四旁。在正常情况下，胃在脾的协同作用下，把营养物质输送到周身。若阳明有邪，亦必影响其他的脏腑。阳明为阳土，主热、主燥。其燥热邪气上扰心神则神昏谵语；上迫于肺，肺气不利则喘而胸满。肝开窍于目，而肾之精上灌瞳子，阳明燥热盛

极，下汲肝肾之阴，阴精竭乏不能上注于目，则目直视不能瞬。见此证者，多属邪盛正衰的危候，故主死。若在以上病情的基础上，更见下利，则表示中焦燥热肆虐，逼迫中、下焦脾、肝、肾之气阴亡脱于下，故亦主死。

发汗多，若重发汗者，亡其阳，**评**语脉短者死；脉自和者不死。
(224)

【解析】本条以脉推断阳明病的预后。

阳明病法多汗，而医生更重发汗，汗出太多，不但亡阴，亦可亡阳。阴阳俱伤而且邪热不解，邪热扰心则**评**语。脉短者，为上不及寸，下不及尺，是气血不足，鼓动无力，血脉不能充盈的反映。**评**语是为邪热盛极；脉短表示正气衰微。脉证不符，正虚而邪实，正不胜邪，故多为死证。如果脉自和，即脉证相符者，说明邪盛而正不虚，虽有神昏**评**语，亦仍可救治。

由此可体会到：对于疾病的预后，人体的正气起着很重要的作用，正气充盛者病易已；正气衰败者证难愈。所以，阳明病见脉沉迟而有力者，尽管症状严重，却易治愈；若脉或短或涩或弱者，则多为不祥之兆。

伤寒若吐、若下后，不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，**濇**者死，微者但发热**评**语者，大承气汤主之。若一服利，止后服。(225)

【解析】本条论述阳明腑实证误失泻下之机而导致正虚邪实的重证。

伤寒，指病的来路，或发汗、或吐、或泻下后，热邪不解，反伤胃中的津液，以致热结阳明，胃肠成实。因阳明主土，万物之所归，无所复传，故邪在阳明可留连较长时间，竟有不大便五六日，甚至十余日的。日晡所发潮热，乃为阳明腑实典型症状之一。不恶寒，为表邪已解，邪气完全凝结于里的反映。独语，即自言自语；如见鬼状，形容神识昏糊而躁扰不宁的状态，这是阴精受伤，热邪干扰心神的反映。此时，当以大承气汤泻下肠胃燥屎则病可愈。如果当下不下，坐失泻下之机，而燥热邪气更盛，正气更衰，则会使病情进一步恶化而出现昏不识人，循衣摸床，肢体躁动不安，精神不宁，微喘直视等脏阴竭乏，阴不敛阳，神不守舍，气不归根等危候。但是，本条若与上条相比，则有轻重程度的不同，上条为死证，本条则仍有可生的一面。何以断其死生，

当以脉辨之。若脉见弦者，弦为端直以长，说明阴气未尽，正气尚存，还有生机，故曰“脉弦者生”；若脉见涩者，涩为细小而短，往来迟滞而不流畅，甚至三、五不匀，至数不清，是营血虚少，阴液已涸，生命难乎为继，故为死证。根据上述病情，张仲景特别提醒医者，当阳明燥热已成，虽但见“发热^证语者”，亦当用大承气汤及时泻下，不能延误时机，以免使病情加剧、恶化。“微者”是与“剧者”相较而言病势为轻，并非指腑实轻证。由于大承气汤属泻下峻剂，故如果一服便利，燥热已下则当止后服。

本条说明，阳明燥热不解，必然耗竭阴液；而阴液之存亡又关系病人的生死转归，因此釜底抽薪，急下存阴就有着极为重要的意义。同时还告诉医者，伤寒治以下法，既不可下之太早，也不可当下不下而坐失时机。下之太早，有伤正邪陷之弊；当下不下，又有耗阴竭液之虞。医者只有随时了解病情变化，辨证以论治，才能恰到好处。

阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕则^证语，小承气汤主之。若一服^证语止，更莫复服。（226）

【解析】本条论述小承气汤证，并以其大便硬为辨证重点，与大承气汤证互相鉴别。

阳明病里热盛，蒸迫津液外泄，所以其人多汗。汗出太多，更伤胃中津液而致胃肠干燥；肠胃津少而失润，则大便必干硬而难以解下；浊热之气上扰心神，故作^证语。此为阳明病的一般发展规律，即由热成燥，由燥成实。由于本证属燥热初结，只见大便硬、^证语等证，所以不用大承气汤，而以小承气汤泻下硬屎为治。若服汤后^证语止者，多为硬屎已下，浊热已去，故不须再服。

阳明病，^证语发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。因与承气汤一升，腹中转失气者，更服一升；若不转失气，勿更与之。明日不大便，脉反微^证者，里虚也，为难治，不可更与承气汤也。（227）

【解析】本条再论小承气汤的脉证及其使用方法与禁忌。

阳明病^证语，是胃中浊热上扰心神所致；潮热，为阳明胃家实的典型发热，见此二证，说明阳明腑实已成，当用承气汤攻下。如果脉见沉迟或沉实有力的，是燥屎内结已深，邪气壅盛，气血受阻，脉道不利的反映，当属大承气汤峻下之证。若见脉滑而疾数，说明阳热虽盛，但燥实结聚未牢，尚未完全敛结成实，此时虽见潮热^证语，亦不能用大承

气汤峻下，而当以小承气汤缓下为宜。但是，在这种情况下，用小承气汤不是按常法服六合，而是加服至一升，即所谓“因与承气汤一升”，增加服用剂量而使泻下作用得到加强。服小承气汤之后，若“腹中转失气者”，又反映出肠中燥屎的转动情况，只因药力所限而未能泻下，当再服一升，以泻下燥屎为目的；“若不转失气”者，说明腑实未成，就不能再用小承气汤，否则将伤害脾胃之气而发生胀满不能食的变证。若服汤后第二天又不大便，脉由滑疾反变为微涩，微主气虚，涩为血少。脉证合参，是为正虚邪实之象，故为难治之证。因气血亏虚，故“不可更与承气汤”。对此，后世有的注家提出用黄龙汤攻补兼施以治疗，此说可资参考。总之，此为证实而脉不实所设的各种推测方法，足以尽可下不可下之辨。仲景因证设方，读之甚有趣味。

对“明日”二字，注家有所争议。日人山田正珍认为“明日”是“阳明”的笔误，是作者从另一个角度来论述阳明病的，即阳明病不大便，脉应见沉实有力，此反微涩者，是里虚之故，故为难治，自然也不可更与承气汤了。这样解释似乎较易理解，故其说值得参考。

阳明病，评语有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但鞭耳，宜大承气汤下之。（228）

【解析】本条以“能食”与“不能食”辨大便燥结的程度。

本论第202条“阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒”，为阳明病的一般规律，乃以“能食”与“不能食”辨寒热。热能杀谷则能食；寒伤胃阳，水谷不能腐熟消磨，故不能食。本条的前提是阳明病见有评语发潮热，为胃家实证已成。胃有热当能食，今却不能食者，是逆其常也，故曰“反”。为什么反不能食？是因肠中有燥屎结滞，肠实而胃满，腑气不通，胃气不降之故。既有燥屎，当用大承气汤峻下，令腑气通胃气降，则诸证可解。文中“宜大承气汤下之”应放在“胃中必有燥屎五六枚也”之后，乃为倒装句法。若能食者，反映胃气还能下降，未至肠实胃满的程度，仅是大便硬，所以只用小承气汤泄热通便即可，无须用大承气汤峻下。

当然，辨大便燥结的程度，不能拘泥于能食不能食这一点，它只不过是辨证中的一个环节而已，本条是对承气汤证辨证内容的一个补充。

阳明病，下血评语者，此为热入血室；但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，濇然汗出则愈。（229）

【解析】本条论热入血室证治，以与阳明腑实证相鉴别。

历代注家对本条所论的热入血室一证有较大争议，争议的焦点在于

此证仅见于妇人，还是男女皆有。多数人认为当专指妇人之病，与“太阳病篇”第151、152、153条的热入血室前后一致，无可非议。然喻嘉言、柯韵伯等人则认为，这里的热入血室是一个广义的概念，男女均可病，在这里则当侧重于男性，叫做男子的热入血室。我们认为此说欠妥，因为血室即胞宫，而男子是没有胞宫的。考《脉经》与《金匮要略》等书，将本证皆列入妇人病中，也证明此证为妇人所独有而与男子无关。因此证有_证语，故列于此处以与阳明腑实证进行鉴别比较。

“阳明病”指阳明经受邪。妇人正值行经期间，血室空虚，在经之邪热不解，可随经而入于血室。热入血室则血中有热，迫血妄行，血室不藏，因而下血。血属阴，由心所主，血热上扰心神，则可发生_证语，与阳明胃家实之_证语证相似而病机不同。血中之热不能透发于外而熏蒸于上，故但头汗出，而身无汗。血室隶属于肝脉，故刺肝经募穴的期门，以疏利肝胆之气而泻血室之邪，使营卫调和、阴阳平衡，正胜邪祛则濈然汗出，热随汗泄而病愈。阳明腑实证也有濈然汗出，乃为里热迫津外渗，为病进；热入血室证的濈然汗出，为营卫调和，驱邪外出的反映，为病退。本条以阳明病，下血，_证语，但头汗出的热入血室证和不大便，_证语，身濈然汗出的阳明腑实证对比发明，实有辨证鉴别的意义在内。

汗出_证语者，以有燥屎在胃中，此为风也，须下之，过经乃可下之。下之若早，语言必乱，以表虚里实故也。下之则愈，宜大承气汤。（230）

【解析】本条论述阳明经腑同病的治疗法则。

本条有两种解释，一种意见认为：汗出为经表之邪未解，_证语为阳明里实，即“有燥屎在胃中”的反映。汗出_证语为经腑同病，故不可下之太早，须待经表之邪过经入腑而完全凝结于里方可下之。如果在经之邪不解而用下法，则表邪入里，表无邪则叫表虚，邪已入于腑则叫里实。里实则_证语更甚，故“语言必乱”。另一种意见，如《伤寒集成》把“此为风也”改为“此为实也”。这样，就可以解释为阳明里热逼迫津液外泄则汗出，阳明实热扰心则_证语，汗出、_证语均是阳明里实热证的见证，而不存在经表之邪。既属里实，治当攻下，下之则愈，宜大承气汤。但是，在泻下的时候要注意是否有经表邪气的存在。若有经邪未解者，不可下之太早，须待经邪解除后，即“过经乃可下之”。否则，下之过早，则表邪乘机内陷，从阳化热，使里实热益甚，则“语言必乱”。可以看出，这两种解释的角度虽有不同，但强调表邪不解者，不可下之过

早的原则却是一致的。

伤寒四五日，脉沉而喘满。沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则^评语。（231）

【解析】本条论述误汗所导致的表虚里实证，与上条误下经邪所导致的表虚里实证相互对比。

伤寒四五日，若按疾病的发展规律，为邪气离表而入里之时。脉不浮而沉主病在里。证见喘满者，为邪在上焦，肺失清肃之令所致。邪在表者宜汗，今邪已入里，不当汗而汗，故曰“反”。反发其汗，则虚其表；津液越出于外，则肠胃津液不滋故大便为难，从而形成了“表虚里实”的证候。时间愈长，津液愈耗，里热愈炽，浊热上扰于心，则见^评语。

三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁而面垢，^评语遗尿。发汗则^评语，下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之。（232）

【解析】本条论述三阳合病而重在阳明，治以清法为主，切不可妄施汗、下。本条若与第104条的三阳证见，治从少阳相类比，可以看出两者的特点各自不同。

三阳合病，为邪势较盛，同时侵及三阳经。太阳经行于背，阳明经行于腹，少阳经行于胁，三阳经被邪热所困，经气不利，背部、腹部和胁部均受影响，但以阳明经之邪热壅盛为重，故腹满身重，甚至难以转侧。口为胃之窍，胃和则口能知五味。今阳明经中有热，胃气失和，故口不能辨味而“不仁”。阳明为多气多血之经，气血旺盛，其经脉布于面，胃热循经上熏，滞于面部，则面如有油垢而不净。热扰心神，则^评语。热迫膀胱而失约，故小便失禁。“若自汗出者”，正说明阳明热盛而迫津外渗。可见此三阳合病，邪热充斥表里内外，而以阳明热盛为主，故当治取阳明，以白虎汤清之。此证表里皆热，以热为主要矛盾，故既不可再发汗以解表，也不能泻下以攻里。若发汗以解表，则更伤胃中津液，热从燥化、胃中干燥，而转属阳明腑证，致^评语更甚；若以泻下之法而攻里，则不仅伤胃阴，而且又能伤阳气。若阴伤于下，而阳脱于上的，则见额上汗出；若阳不达四末，阴阳气不相顺接的，则见手足厥冷，均为误治之所致。

二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足^{桡桡}汗出，大便难而^评语者，下之则愈，宜大承气汤。（233）

【解析】本条论述二阳并病转为阳明腑实的证治。

“二阳”指太阳与阳明。“并病”，是先病太阳而后病阳明。在伤寒病变过程中，太阳之邪不解可渐次化热入里而形成阳明病。若太阳证仍在，则为表里同病，也称“二阳并病”。二阳并病，若太阳证已罢，即发热恶寒不复存在而只见发潮热，手足^{热热}汗出，大便难而^譫语者，说明邪热已尽并于胃，阳明腑实业已形成。根据第220条所说：“阳明病……不恶寒……有潮热者，此外欲解，可攻里也，手足濇然而汗出者，此大便已硬也，大承气汤主之”，故当以大承气汤下之则愈。

本条所述内容与上条比较：一为阳明散漫之热，宜清而不宜下；本条为胃腑成实，宜下而不宜清。示人只有辨证分明，谨守病机，各司其属，才能治疗得当，而恰如其分。

阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，反恶热，身重。若发汗则躁，心愠愠，反^譫语；若加烧针，必怵惕烦躁，不得眠；若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊^懊，舌上胎者，栀子豉汤主之。（234）

【解析】本条论述阳明热证误治后的各种变证。

“阳明病，脉浮而紧”，与太阳伤寒之脉相似，但从“发热汗出，不恶寒，反恶热”之证可知，此并非太阳表不解，而是阳明表里热盛的反映。阳明经热盛可见脉浮，阳明腑热盛可见脉紧，今浮紧同见，则知阳明热虽盛，而里却未成实，仍为阳明热证范围。热蒸于上而津伤，故“咽燥口苦”；热壅于里而气机不利，则“腹满而喘”；邪热充斥于内外，经气不利，则“身重”。本证属于阳明的热证，则非汗、下之所宜，当用清热之法治之。

若误将脉浮紧、发热辨为邪在表，而用辛温发汗法治疗，则必助热伤津。热扰心神，神失濡养，则会导致躁扰、昏乱、^譫语等变证丛生。“愠愠”，即昏乱、神识糊涂的意思。若加烧针以劫汗，不仅伤心液，而且有惊恐伤肾之虑。心肾受伤，水火不能既济，肾水不能上滋，心火不能下交，故怵惕烦躁而不得眠。若下之则伤其胃气，使胃中空虚，邪热乘虚而入。无形之邪热动犯胸膈，即“客气动膈”，则见心中懊^懊、烦郁特甚之证。因其证属于郁热，故以舌上黄苔为凭。治以栀子豉汤清宣郁热而除烦懊。

栀子豉汤是治疗太阳热郁较深，而阳明热郁较浅的膈间火郁证的主方。取栀子轻清苦泄、豆豉轻宣透邪之作用，既不令其热竭津液，又不令其邪气入胃，使郁热之邪得清则病愈。

若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。（235）

【解析】本条承上条，论述热邪由上焦胸膈入于中焦的证治。

如果热邪入于中焦，伤及胃中津液，则出现口干舌燥，渴欲饮水的证候。当治以白虎加人参汤。用白虎汤以清热，加人参以生津止渴，使邪热清，津液复，而渴欲饮水、口干舌燥等证则自愈。

若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。（236）

猪苓汤方：

猪苓去皮 茯苓 阿胶 滑石碎 泽泻各一两

上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，内下阿胶烊消，温服七合，日三服。

【解析】本条承前两条，进一步论述热与水结于下焦的证治。

本条可做两种解释：一种认为应与第234条的误下之后相连接。也就是说，因误下之后，热邪深入下焦，下焦指肾与膀胱，它们一为水脏，一为水腑。热邪与下焦水液互结，气化不行则小便不利；热为阳邪，气腾于外，故见脉浮；热与水蓄，津不上承，故渴欲饮水。另一种认为，应与白虎加人参汤证相连接。白虎加人参汤证本有发热，脉浮滑，渴欲饮水之证。若饮水多，汗出也多，水随汗泄，则不能形成蓄水证；若饮水多而不能汗出，水无出路，则必然停蓄不行，形成下焦蓄水证。由于因热而蓄水，水与热互结为病，故证见脉浮发热、小便不利。虽然两种解释不同，但最终形成水热互结证则是一致的看法。

治病必求于本。下焦蓄水之本，主要病变在于肾和膀胱。其中因肾阳虚寒，不能温阳化水而致水饮泛滥者，则用真武汤温阳祛寒以镇水；因太阳膀胱气化不利而蓄水者，当与五苓散助气化、利水邪以行津液；今因热盛阴伤，水热互结于下焦者，则用猪苓汤清热育阴以利水。可见虽然都属下焦蓄水，但却有阴阳、表里、寒热的不同。

猪苓汤用猪苓、茯苓、泽泻淡渗利水，茯苓兼以安神定志、交通心肾；泽泻能行水上，使水之阴津上滋，故在利水之中兼补阴分之不足；滑石清热利水通淋，导热下行，实有调和阴阳升降的意义；阿胶为血肉有情之品，味厚而甘，以滋真阴之虚。陈修园总结本方为清热育阴利水之法。

临床经验证明，用猪苓汤治疗以下疾病，多能收到满意的疗效：

1.急性肾盂肾炎

症见发热，溺血，心烦不眠，腰中疼痛，脉弦细，舌红少苔者，以本方加旱莲草20克至30克，三七粉1克（冲服），女贞子10克每多获效。

2.肾结核

症见尿血，腰痛，五心烦热或伴有低热，脉弦细数，舌红少苔者，可用本方加一些滋阴药如生地、天冬等。

3.妇人泌尿系感染

症见尿频、尿急、尿痛，小便灼热，发热，心烦，脉细数，舌红者为宜。

以上原文第234条、235条、236条连为一体，是论误下阳明热证所导致的三种证候。张仲景连用五个“若”字，以示设法御变的灵活性，并提出相应的救治方法。柯韵伯将此总结为阳明病“开手三法”，即阳明热邪内入，或上、或中、或下的三个不同阶段的治法。热在上者，以栀子豉汤清宣火郁；热在中者，以白虎加人参汤清热生津；热在下者，以猪苓汤清热育阴以利水。从而为辨治阳明热在三焦提出了辨证纲目。

阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。（237）

【解析】本条论述猪苓汤的禁忌证，以与白虎加人参汤证相鉴别。

猪苓汤为临床常用方，但在运用时必须严格辨证，才能做到治疗无误。若脉浮发热，口渴欲饮水，无汗而小便不利，则为水蓄下焦之口渴，方可与猪苓汤清热育阴利水；若口渴饮水多，汗出亦多，小便利者，则为燥热伤津之渴，应与白虎加人参汤清热生津，而不可误投猪苓汤。因为猪苓汤虽然有阿胶滋阴，但毕竟是利水之剂，若复利小便，将更伤津液而反增其燥，故不可与之。

脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者，四逆汤主之。（238）

【解析】本条论述表热里寒的格阳证治，以资与阳明病的热证对比鉴别。

“脉浮而迟，表热里寒”，作者提示了疾病的本质是寒而非热。肾为阳气之根，故阳气藏于阴内。少阴阳虚，则阴寒内盛，逼迫阳气不能潜藏于下，而反浮越于外，故脉浮而周身发热，甚或兼见汗出。此证貌似阳明之热证，实是少阴阴寒之所致，故脉兼迟象而见下利清谷等寒证。治当急温少阴，引阳归根则愈。

若误认发热脉浮为阳证，或汗或下皆令阳气损伤、阴寒增加而预后不良。

若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。（239）

【解析】本条承上条，论胃虚之寒证。

上条论少阴阳虚阴盛的格阳证。本条所论则是阳明虚寒。“胃中虚冷”，腐熟无权，水谷不能运化，故不能食。若饮水，由于水寒内抑胃阳，使胃中虚寒更甚，胃气不降，因而产生呃忒之变。继阳明热证以后，又辨阳明的虚寒证，对仗颇工，引人深思。

脉浮发热，口干鼻燥，能食者则衄。（240）

【解析】本条论述阳明经热作衄。

足阳明胃之经脉，起于鼻旁，环口，循于面部。证见脉浮发热，口干鼻燥，说明阳明经中有热。热能消谷，邪只在经而未入于腑，胃气尚和，故能食。经脉为血行之道路，热在经中，迫血妄行，则见衄血。正如成无己所云：“脉浮发热，口干鼻燥者，热在经也；能食者，里和也。热甚于经，迫血为衄。”由于邪热可随衄作解，故衄血亦有自愈之机。

关于自衄作解的问题，在“太阳病篇”已讲到，当邪在太阳经以衄作解时，往往见有发烦、目瞑等证，剧则必衄，为阳气重之故；若在阳明经中时，只要见到口干鼻燥，能食而胃气强者，则可作衄而解。

以上三条，一为少阴阳虚阴盛的格阳证；一为胃阳不足，中焦虚寒证；一为阳明经中有热之证。通过对三者病变部位的深浅，证候性质的寒热等方面比较分析，而具有一定的辨证意义。

阳明病下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊憹，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。（241）

【解析】本条补述阳明病热郁胸膈的证治。

“阳明病”，在此指阳明经表之证。既然邪在经表，治当以汗法宣透，使邪气从外而解。如果误用下法，则在经之邪不解，乘机内陷而化热。邪热内陷胸膈，若与痰水相结，可形成结胸证；若不与痰水结，而

热邪郁于胸膈，则外见身热、手足温；郁热扰心，则“心中懊^怏”；郁热影响胃气不和，所以“饥不能食”，热能消谷，故知饥而有饥饿感；但属郁热，胃气被抑，故虽饥而不能食，此与胃家虚寒的不欲食，而无饥饿感者不同。“但头汗出”是被郁之热不能向外散发而上熏所致，此又与阳明燥热的周身或手足汗出濇然者有别。根据火郁则发之的治疗法则，当治以栀子豉汤清透胸膈之热则愈。柯韵伯认为：此种心中懊^怏之证，是“上焦火郁不达”，所以服栀子豉汤后，必然要吐，吐则火郁得发，邪气因之而解。

本条承第234条补述了阳明病热郁胸膈的证候。再与第235条的白虎加人参汤证，第236条的猪苓汤证联系起来看，则都属阳明病的里热证，但尚未构成胃家实。从病情看，在上的栀子豉汤证为火郁；在中的白虎加人参汤证为胃燥；在下的猪苓汤证为水结。此阳明清法三方，即前述柯韵伯所谓阳明病热证的“开手三法”。栀子豉汤证与白虎加人参汤证的主要鉴别点在于：栀子豉汤证见心中懊^怏，头汗出等证，病变部位较高，且偏于外，处在太阳与阳明的表里交界处，所以柯韵伯称其为“半表半里”证。白虎加人参汤证是阳明里热证，热邪由里向外蒸腾，故见烦渴引饮，周身汗出等证，病变部位偏里，而且热势也重，且有气津两伤的表现。

阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，小柴胡汤主之。（242）

【解析】本条论述少阳阳明并病，治取少阳之法。

“阳明病，发潮热”，一般见于阳明腑实证，当伴有大便燥结不下，小便数多等证。而今却见“大便溏，小便自可”，说明虽病及阳明，但并未形成胃肠燥热结实。“胸胁满不去者”，为少阳之邪仍在。故此属少阳阳明并病，少阳之邪未解，而阳明未实之证。治疗则忌泻下，应以小柴胡汤治少阳为宜。因少阳枢机畅达，则上焦得通，津液得下，胃气因和，其潮热也将随身濇然汗出而解。

《苏沈良方》曾指出小柴胡汤可以治疗烦热、潮热、往来寒热、差后劳复发热、呕而发热等五种热，其治潮热的根据就来自本条。

阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白胎者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濇然而汗出解也。（243）

【解析】本条论述阳明少阳合病的证候及治取少阳的机理。

“阳明病”，在此指“不大便”而言，如不大便伴有潮热、^譫语、腹满疼痛、舌苔黄燥等证，则属阳明燥实无疑。而今虽见不大便，但伴

有“胁下鞭满”和呕吐的少阳见证。且“舌上白胎”，胎同苔，即白苔，更说明了里无燥热可言。因此，“不大便”一证，并非阳明腑实，而是由于少阳枢机不利津液不下达所致。少阳受邪，经气不利，则胁下硬满；影响胃气不和，则生呕吐；气郁而津液不达、肠道失润，故大便不下。此虽为阳明与少阳合病，但也不能用大柴胡汤治疗，因阳明并无燥热之象，故当治以小柴胡汤为允。

小柴胡汤有和解少阳，疏利肝胆，通利三焦的作用。《难经·三十一难》说：“三焦者，水谷之道路，气之所终始也。”少阳之气不利，则影响三焦水道不能通畅。上焦不通，津液不得下达以濡润大肠，则大便秘结不下。治用小柴胡汤和解少阳，使三焦气机通畅，津液布达，胃气调和，邪去正安，则大便自调，胁下硬满可除，呕恶自止。故指出“上焦得通，津液得下，胃气因和，身濇然而汗出解也”。

以上两条，皆论阳明少阳同病，一为发潮热，大便溏，小便自可；一为不大便而呕。由于它们都有胸胁满闷的少阳主证，且阳明胃家不实，故治从少阳为得法。小柴胡汤兼治阳明病发潮热或不大便，可以说又推广了它的应用范围，但临证时必须坚持辨证论治的原则，这两条所说的“大便溏，小便自可”和“舌上白胎”，则是辨证的眼目，切不可忽视。

阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干不得汗，嗜卧，一身及面目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之小差。外不解，病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤。脉但浮，无余证者，与麻黄汤；若不尿，腹满加哕者，不治。

（244）

【解析】本条论述阳明少阳同病，湿热发黄的证治。

“阳明中风”，即阳明经被风邪所伤。弦为少阳之脉，浮大为阳明之脉。“脉弦浮大”，提示少阳阳明两经受邪。“短气，腹都满”，是阳明腑热郁闭的表现；“腹都满”，是全腹都胀满。阳明经脉挟鼻而行，邪热闭郁阳明经脉，故鼻干不得汗。邪客阳明，阳气怫郁，因而发热一证自在言外。从上述脉证可知，本证为阳明经腑同时受邪。但从脉浮大而非沉迟、沉紧，证虽有潮热，然不见大便难、腹痛拒按，可知阳明经表之邪热并未尽归于腑而成阳明腑实证。少阳经脉布于人体两侧，少阳受邪，经气郁遏，疏泄不利，故胁下连及心痛，即使久按之，气也不通，胀痛不减。少阳三焦之气不利，水道不畅，故“小便难”。水道不畅，从而导致水湿内停，与热互结，湿热熏蒸，则一身及面目皆黄染，从而形成黄疸。湿性黏腻重浊，与热互结又可阻遏气机，故嗜卧而身重。少阳气

郁，枢机不利，影响胃气上逆，故时时出现哕逆之证。足阳明胃经循行于耳前；足少阳胆经的分支从耳后分出，进入耳中，出于耳前，故两经受邪，邪热壅滞经脉，则“耳前后肿”。此证与“颐毒”相似，其治可用针刺之法，以疏通经脉。由于邪气盛，病情重，故针刺后也只是脉证少平而外邪仍不解，此即所谓“刺之小差，外不解”。针刺何穴，文中没有记载。根据前人治痄腮（发颐）的经验，可刺支沟、曲池等穴，以泻阳明少阳之邪热，可资参考。

“外不解”，既指“胁下及心痛”的少阳经证仍在，也言潮热、鼻干不得汗等阳明经表之证未解。若病过十日，脉续浮，即弦浮大脉象不变的，说明病程虽长，但脉证未变，邪仍在经表，未传于里，故其治还当与小柴胡汤和解。为什么阳明、少阳两经合邪治以和解而不用清下呢？原因有二：一是少阳有三禁，即禁汗、吐、下；二是本证以少阳脉证为主，故虽有阳明病，亦当用和解之法，而治从少阳。小柴胡汤可以和解半表半里，使其枢机通利，则表里之邪热皆除。况且方中柴胡、黄芩又有利胆退黄的作用，因此柴胡剂是治疗黄疸的常选方剂。《金匮要略·黄疸病脉证并治》记载：“诸黄，腹痛而呕者，宜柴胡汤。”本条所述脉证为阳明少阳同病而又有湿热发黄，因此选用小柴胡汤以疏利肝胆，通畅三焦，清利湿热，也是非常适宜的。“与小柴胡汤”，有根据具体病情，灵活加减化裁之意，“与”、“主之”的提法有别。因本证有小便难，一身面目悉黄，胁下及心痛，久按气不通等湿热交阻，气郁不疏的见证，故应去大枣以防增湿助满。陈修园有歌诀云：“胁下痞硬大枣除，牡蛎四两应生杵”，即指出不但要去大枣，还应加生牡蛎以软坚止痛。为了加强清利湿热以退黄的治疗效果，还可加茵陈及与五苓散等清利、渗湿药物合方使用。治疗耳前后肿，也可适当加连翘、贝母等清热散结之药。总之，在辨证论治的原则指导下，可以灵活使用方药，即所谓“师其法而不泥其方”。

若“脉但浮，无余证”，即其脉只浮而不见弦大，又没有其他的里证，说明病在太阳之表，可与麻黄汤发汗以解表邪。

“若不尿，腹满加哕者，不治”，是言黄疸危重证及其预后。不尿，即小便闭。小便闭，则湿无出路，壅遏气机，故腹满益甚。胃气逆而不降，则哕逆不止。不尿，腹满谓之“关”，呃逆不止谓之“格”。关格之证出现，是阴阳之气不通，升降气机不利所致。既然一身气机升降功能已绝，其病必然难以治愈，故曰“不治”。此时若再试图以小柴胡汤使其达到“上焦得通，津液得下，胃气因和，身濇然汗出而病解”，则往往是不可能实现的了。

阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽鞭不

可攻之，当须自欲大便，宜蜜煎导而通之。若土瓜根及与大猪胆汁，皆可为导。（245）

蜜煎导方：

蜜七合一味，内铜器中微火煎之，稍凝似饴状，搅之勿令焦著，欲可丸，并手捻作挺，令头锐，大如指，长二寸许，当热时急作，冷则鞭。以内谷道中，以手急抱，欲大便时乃去之。

猪胆汁方：

大猪胆一枚，泻汁，和醋少许，以灌谷道中，如一食顷，当大便出。

【解析】本条论述阳明病的导下之法。

“自汗出”，本是阳明病外证。汗出津液已伤，如果再发其汗，则更伤津液。津液损伤，小便当不利，今小便自利者，则为津液偏渗不能还于胃肠，胃肠更燥，此即所谓“津液内竭”。胃肠津亏，大便必硬。但与阳明腑实证的大便硬根本不同。阳明腑实的大便硬是内有邪热，因热伤津，津亏成燥，燥热成实而致，其临床表现有腹满痛，拒按，潮热，谵语等证，而其人往往是没有便意的；本证之大便硬，乃因津液内竭所致，多无腹满痛、潮热、谵语等证，此证的病位在直肠，虽时有便意，但大便却难以排出体外。由于二者病机不同，因此治法也异。阳明腑实治以承气汤类荡涤胃肠的燥热结实。而此证之大便硬，因其部位仅在直肠，所以“当须自欲大便”，即大便下近魄门不能出时可因势利导，用蜜煎导、猪胆汁或土瓜根纳入谷道，导之即下。

本论导便之法，在医学史上可谓一个创举，它先于西方医学500余年。本条介绍三方虽皆可为导，但具体应用时又有所不同：因蜜有滑利润燥的作用，故蜜煎导宜于肠燥之便秘；猪胆汁不仅润燥且能清肠中之热，故宜于肠燥之有热的便秘；土瓜根则有宣气润燥之功，故宜于六腑之气不畅，气血不利之便秘。有的医家认为冬季导使用蜜煎导，夏季导使用猪胆汁，其说也可参考。

蜜煎导法是用蜂蜜放入铜器内，微火煎熬成饴糖状，待其凝缩可成

丸时，做成二寸长的蜜挺，趁热纳入肛门内。本论土瓜根方已佚，据《肘后备急方》载：用土瓜根捣汁，灌入肛门，即可通便。猪胆汁灌肠法，是取大猪胆一枚，泻出胆汁，加入少许米醋，用以灌肠，取其酸苦涌泄而不伤津液。

本条介绍的外导灌肠之法，适用于津亏便秘，此证虽属阳明病，但绝非燥热内结，燥屎不下的阳明腑实证，如误以承气攻下，必致津液下夺而更甚。这也提示人们，对于高年体弱、产妇婴幼及素体阴亏血虚而见大便秘结的患者，不可滥用苦寒攻下，而应酌用外导之法。

阳明病脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。（246）

【解析】本条论述邪伤阳明经表治以桂枝汤的脉证。

“阳明病法多汗”，故“汗出多”，则为阳明病应有之证。然阳明病不应有恶寒，今“微恶寒”，又似邪在太阳之表，但又不見头项强痛等太阳经主证，故也非太阳的表证。今就汗出多，微恶寒，脉迟等证分析，可知此证为风寒之邪伤于阳明经表。三阳经脉皆外行体表，而内属六腑，故其为病也均有经、腑之分。因经证属表，腑证属里，故经证也可称表证。考太阳经表之证，病位较浅，故恶寒重而汗出少。阳明经表之证，病位略深，故恶寒轻而汗出多，此为邪在肌表将欲传里而表又未罢之象。因其脉迟而汗出多，仍属于表虚范围，故以桂枝汤解肌发汗，以散阳明经表之邪。

阳明病脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。（247）

【解析】本条论述邪伤阳明经表，治以麻黄汤的脉证。

上条论阳明病“微恶寒者”，为表未解。本条之“阳明病脉浮”，亦指出邪在阳明经表未解。阳明风寒外束，无汗而表实，表邪郁肺，气失宣降，故气逆而作喘，治用麻黄汤发汗。另外，阳明经脉行于面部，因而或可出现目痛、鼻干、额头作痛、缘缘面赤等证，治宜葛根汤发汗，则病可愈。

以上两条，皆论阳明经表之证，一为汗出表虚，一为无汗表实，分别用桂枝汤与麻黄汤治疗。两条对比，则有辨证鉴别的意义在内。有的注家认为这两条所论，乃太阳与阳明表里同病，根据表里同病当先解表后攻其里的法则，故先以桂枝汤或麻黄汤以解太阳之表。此说可资参考。

阳明病，发热汗出，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，

茵陈蒿汤主之。（248）

茵陈蒿汤方：

茵陈蒿六两 梔子十四枚，擘 大黄二两，去皮

上三味，以水一斗，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分温三服，小便当利，尿如皂角汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

【解析】本条论述阳明病湿热发黄，热重于湿的证治。

阳明与太阴为表里，阳明主燥，太阴主湿。入里之热邪，可从阳明燥化，亦可从太阴湿化。热从燥化，则大便干燥，小便数多，而发展为阳明腑实证；热从湿化，湿热相合，则小便少、头汗出，而发展为黄疸。无论燥热或湿热，都与阳明之热有关，这就是将湿热发黄放在“阳明病篇”论述的理由根据。

“阳明病，发热汗出，此为热越，不能发黄也”，指出了阳明病热盛津伤而燥化的见证与病机，发热汗出，是阳明热盛迫津外泄。汗多必更伤津液，津伤化燥，则大便因硬，从而形成了阳明燥实证。若阳明病仅见头部汗出，剂颈而还，周身无汗，而小便不利，说明热不得越而湿亦不得泄。湿热相合，热欲外越却因湿邪羁縻而不得越，故但头汗出，而周身无汗。湿欲下泄，却因热邪纠缠，而反小便不利。“热不得越，湿不得泄”，湿热郁阻于内，即所谓“瘀热在里”，而熏蒸于外，则身必发黄。湿热交阻，气化不行，津液不布，故其人“渴引水浆”。在这里“头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利”，不仅是湿热郁阻之象，而且也是形成湿热病的重要原因，因此带有重要的辨证意义。湿热发黄，有以湿盛为主者，有以热盛为主者，也有湿热相当者。本证有发热、渴饮水浆等证，说明热重于湿，治用茵陈蒿汤清利湿热。

茵陈蒿汤由茵陈、梔子、大黄三药组成。茵陈清热利胆除黄，为治诸黄专药，无论阳黄、阴黄均可使用，对于阳黄亦可单用一味水煎频饮，其日用量可达30克以上。大黄的特点善于破结行瘀，推陈致新，泄热导滞，故仲景对凝结的病证，如燥结、水结、血结等，每每用之，其破结之力自非一般药物所能及。本证湿热发黄，为湿热胶结并涉及血分，故谓“瘀热在里”，用大黄不仅能荡涤肠胃以泻热实，而且能行血导滞，以破湿热之蕴结。梔子苦寒而质轻，善清三焦，利小便，驱湿热下行，以导邪从小便而出。三药合用，主要使瘀热、湿浊从小便排出，故

方后注云：“分温三服，小便当利，尿如皂角汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。”这不仅说明本方的主要作用是导湿热而利小便，也补充说明本方湿热发黄应有腹满一证。

由此观之，本方与承气汤作用截然不同：承气汤专事攻下，使阳明燥热从大便而下；本方则以利尿为主，使阳明湿热从小便而去。

临床使用茵陈蒿汤治疗各种黄疸，已被大家所习用。特别是对治疗肝胆疾患所引起的黄疸，无论急性、慢性，多能取效。但要注意，由于湿为黏腻之邪，其病多缠绵难愈，故用此方治湿热黄疸，应该有耐心，不可操之过急，且务必使湿热邪气尽去方能罢手，否则病情反复，将更难医治。

阳明证，其人喜忘者，必有畜血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘，屎虽鞭，大便反易，其色必黑，宜抵当汤下之。（249）

【解析】本条论述阳明蓄血证治。

因有大便硬，故称阳明病。“喜忘”，即善忘，言听视动，随过即忘，乃因“久有瘀血”所致。心主血脉，又主神志，若血液充盈、环流不息，则心能主神任物，聪慧敏锐，记忆力强；若久有瘀血，血脉不利，心失所养则记忆力亦必然减退。《内经》所谓：“血并于下，气并于上，乱而喜忘”。张景岳注释说：“血并于下则阴气不升，气并于上则阳气不降，阴阳离散，故神乱而喜忘。”阐明了瘀血导致善忘的病机。因“血主濡之”，瘀血在肠，与燥屎相混，故大便反易解下，即所谓“屎虽鞭，大便反易”。瘀血混于粪便之中，故大便之色必黑，甚至状若黏漆。以上是阳明蓄血区别于阳明腑实的主要特点，此证是久瘀血与阳明之邪热相合，故治宜抵当汤泄热逐瘀。

曾治一女姓患者，30岁，河南人。1969年患精神分裂症，住某医院治疗，尚未痊愈即出院。出院后患者总感头皮发紧，如勒铁箍，言听视动，随过即忘，记忆力严重减退。月经不畅，经来腹痛。察其神色，两目呆滞、神情淡漠。舌苔黄腻，脉沉滑。诊为瘀血内停，血脉不利，心神失养。治以活血化瘀之法：先投抵当汤加柴胡、半夏；中转桂枝茯苓丸合失笑散；最后以大黄6克、桃仁15克、炙甘草6克、芒硝6克、丹皮9克、赤芍9克、郁金9克、菖蒲9克，药后患者大便排出秽物甚多，继而头部渐渐清爽，记忆力明显增强，其他各种病痛也相继好转，患者乃携方归里。

古今用活血化瘀法治疗精神病而取得疗效者，屡见不鲜。因为活血化瘀，可使瘀血去，血脉通，血奉于心，心得血养，则神志自明。然引起精神失常的原因很多，属瘀血者只是其中之一，只有辨证确属瘀血，

用活血化瘀法才能取效。

阳明病，下之，心中懊^怱而烦，胃中有燥屎者可攻。腹微满，初头鞕，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。（250）

【解析】本条论述阳明病可下与不可下的辨证。

阳明病，若为腑实，当用下法，用之得当，则实热去而病愈，用之不当，亦有病不愈的，如第241条“阳明病下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊^怱，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之”，即是下后余热不尽而扰于胸膈之证。因无实邪凝结，故属虚烦懊^怱。本条阳明病下后，虽亦见心中懊^怱而烦，但其原因却是下后燥热未尽。复结成实，肠中有燥屎，浊热上扰，故见心烦特甚，此即所谓“胃中有燥屎”，其烦当属实烦，所以治仍“可攻”，宜大承气汤。

阳明腑实已成，必见腹满疼痛拒按，大便干硬难下等大实大满之证。若仅见“腹微满”，其大便为“初头鞕，后必溏”，则腑实未成，或属脾虚不运，水谷不别之“固瘕”证，故“不可攻之”。

病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。（251）

【解析】本条论述阳明燥屎的可下证。

上条言“胃中有燥屎者，可攻”，何以知胃中有燥屎，本条作了回答：“病人不大便五六日，绕脐痛”，即围绕着脐周围的腹部作痛，正是肠中有燥屎内结，阻塞气机，腑气不通的反映。浊热扰心，故见“烦躁”。由于阳明旺于申、酉时，故当日晡阳明气旺之时，正邪斗争激烈，诸证发作加剧。燥屎内结是病机所在，或者说不大便，是绕脐痛、烦躁之由。故云：“此有燥屎，故使不大便也。”因上条已指明“若有燥屎者，宜大承气汤”，故本条不言治法，乃是省文。

从《伤寒论》大承气汤证的有关条文来看，“有燥屎”可以说是用大承气汤泻下的一个重要指征。所谓燥屎，系指积留于大肠所形成的异常干燥的粪块。它不同于一般的大便硬，其形状如球不等，但均有顽固难下的特点，有时还可通过腹诊触摸到屎块。本条所举之“绕脐痛”，又是辨燥屎的一个重要证候。只有在辨证准确的前提下，使用大承气汤峻下才能做到心中有数。

病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也。脉实者宜下之；脉浮虚者，宜发汗。下之与大承气汤，发汗宜桂枝汤。（252）

【解析】本条论述表里证的辨证与治疗。

第250条讲的是下后病不解，有可攻、不可攻之辨；本条论述汗后病不解，有可汗与可下之别，两条对参，充实了阳明病大承气汤的辨证内容。

“病人烦热”，说明热势较甚。若属太阳之表，则汗出表解而热除。今汗出后又出现了阵寒阵热、寒热如疟之证，为太阳表邪未尽，尚有小邪不解；“日晡所发热者”是里实热的反映，故曰“属阳明也”。此太阳、阳明证俱见，即表里同病，其治当根据病情的轻重缓急而有所区别。如见实脉，即三部有力的脉象，表明其证以胃家实为主，宜以下法泻其实，用大承气汤；若见脉浮而虚，即脉浮缓而弱，提示其证重在太阳，宜以汗法解其表，可用桂枝汤，而不能用大承气汤。

本条举一证一脉，即潮热、脉实作为辨阳明胃家实的客观指征，强调了脉证合参的辨证论治重要性，并进而补充了大承气汤的辨证要点。

大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。（253）

【解析】本条论述大下后燥屎复结的证治。

“大下后”的提法，言外之意因有可下之证，才用过了大承气汤。经大下后，又“六七日不大便”，并出现“烦不解”且有腹部胀满疼痛之证，说明泻下未尽仍有燥屎。既已大下，为何又有燥屎？“所以然者，本有宿食故也”，作者对下之不尽作了注语，意是在病阳明之前即素有食积内停，而后又与燥热相合，故而比较顽固难下。一次大下不能尽除，燥屎又再次复结；或因六七日不大便，纳食而不化，糟粕不能排出，与下后未尽之燥热相结，形成燥屎。既有宿食不解、燥屎复结，则当再下，故用大承气汤。

太阳病有一汗表邪未尽而可再汗之法，阳明病亦有腑实一下不除而可再下之法。能否再汗与再下，均要从辨证以论治。本条所言“大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者”，正是阳明腑实不解，内有燥屎的典型证候，故可再下方不失病机。

病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。（254）

【解析】本条论述燥屎内结，而证见大便乍难乍易的辨识方法。

阳明病的腑实证，在一般情况下，多是大便秘结七八日、八九日，甚至十余日不下。而本证却是“大便乍难乍易”，即大便时通时不通。说明既有燥屎内结，又有热结旁流，结者难下，旁流者时下，故形成大便

乍难乍易的特点。肠中有燥屎，燥热逼迫津液偏渗于膀胱，则小便当数多。但若燥热内盛，灼伤津液，津液内乏，则可见小便不利。燥屎内结，邪热深伏于里，故外见反微，即所谓“时有微热”。肺与大肠相表里，今燥屎内结，腑气不通，影响肺气不降，则作喘；燥热上攻，清阳不升，所以眩冒，“喘冒不能卧”，则言喘、冒之甚。

以上从第250条至254条，从各个不同角度阐述了阳明胃家实治以大承气汤的可下之证，其重点在于辨燥屎的已成。通过以上的烦躁、日晡潮热、腹满痛、绕脐痛、不大便、脉实等证，以及小便不利、大便乍难乍易、时而微热、喘冒不能卧等证，作者把燥屎已成的各种表现已囊括无遗。

食谷欲呕者，属阳明也，吴茱萸汤主之。得汤反剧者，属上焦也。（255）

吴茱萸汤方：

吴茱萸一升，洗 人参三两 生姜六两，切 大枣十二枚，擘

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。

【解析】本条论述胃气虚寒，食谷欲呕的证治，以及上焦有热呕吐之辨。

呕为胃气上逆之象，故曰“食谷欲呕者，属阳明也”。阳明属胃，主受纳、腐熟水谷，其气以下降为顺。胃气虚寒，不能腐熟水谷而气上逆，故食谷则欲呕吐。且胃气虚寒，易生饮邪，故常伴脉弦、胸闷、呕吐涎沫等证。治当以吴茱萸汤温胃散寒，降逆止呕。只要辨证准确，服本方多能药到病除。但若辨证不准，用之亦有不效而呕吐反剧者。这可能因其证属胸膈有热而胃中有寒，误投吴茱萸汤则必助热而不受，致使其吐益甚。故曰“得汤反剧者，属上焦也”。

吴茱萸汤由吴茱萸、人参、生姜、大枣四味药组成。吴茱萸为方中主药，性味辛苦而热，善能暖肝胃而下气降浊；人参、大枣甘温以补益中气，崇土以制木；重用生姜，温胃散寒化饮，以降逆止呕。因此证夹水饮之邪，所以不用甘草之缓恋。

通常所言阳明病，人们常想到白虎汤证和承气汤证，至于用吴茱萸汤治疗阳明病，似乎难以理解，所以有人竟提出吴茱萸汤证不应放在“阳明病篇”。这反映出其对阳明病缺乏全面了解。纵观《伤寒

论》“阳明病篇”，应该说“胃家实”确是阳明病辨证论治的主要方面，但并非阳明病的唯一证候。因为阳明病还包括了表、里、寒、热、虚、实诸种病证，其中的吴茱萸汤证就是一例。《伤寒论》的每经之为病，常从阴阳、表里、寒热、虚实等矛盾对立的两方面对临床病证进行论述、分析、比较，以扩大人们的辨证视野，提高人们的辨证能力，这也正是这部书最可宝贵的地方。

太阳病，寸缓、关浮、尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也。如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必鞭，不更衣十日，无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。（256）

【解析】本条论述太阳病误下致变及转属阳明的辨证。

本条论述了太阳中风误下的心下痞证；不恶寒而渴的转属阳明证；小便数大便必硬的脾约证；口渴而小便不利的膀胱蓄水证。

“太阳病，寸缓、关浮、尺弱”，即指太阳中风阳浮阴弱之脉而言；发热、汗出、恶寒（恶风之互词）为太阳中风表虚之证。邪在太阳，当以汗解，本不应攻下。若医者误下，则必先伤胃气，使表邪内陷，结于心下，气机痞塞，而形成心下痞，即所谓“但心下痞者，此以医下之也”。若未经误下而出现不恶寒，但口渴之证，是邪气传入于阳明，而成热盛津伤，故见此证。因其不见潮热、谵语、腹满痛等证，故虽是转属阳明，但未成腑实可下之证。若虽亦转属阳明，但见小便数，大便硬，不更衣，无所苦之证，则属胃强脾弱，脾不能为胃行其津液的脾约证。脾约证，是由于津液被伤，胃肠燥热，脾阴被胃阳所约束，不能行津液于胃中，而致大便硬，虽不更衣无所苦也。此与正阳阳明因热成燥，因燥成实，腑气不通，而致腹满疼痛拒按者不同。若口渴喜饮水，可先少少与饮之，以和胃气，待辨明口渴的原因，再以法治之。如见口渴，小便不利，是属膀胱气化不利而停水，宜用五苓散化气利水，使水邪去，则津液得以上承，口渴自止。

总的来看，这一条提出了太阳中风的几种转归：有经误下形成的心下痞证；有不经误下自然传变而转属阳明：阳明证既有口渴为主的热证，也有不更衣十日无所苦的脾约证。同时又举出膀胱蓄水而见口渴的五苓散证，又含有与阳明热盛津伤的口渴作鉴别之意。

脉阳微而汗出少者，为自和也；汗出多者，为太过。（257）

【解析】本条以汗出多少辨太过与自和。

“脉阳微”，指脉浮而微，反映邪气微而表邪不甚。“汗出少”，指汗

出适当，反映正胜而邪去，故谓“自和”。若汗出多，则反伤正气，易使阴分不足，阳气有余，因而便为形成胃肠燥热创造了一个主要条件，阳热“为太过”。

阳脉实，因发其汗出多者，亦为太过。太过为阳绝于里，亡津液，大便因鞅也。（258）

【解析】本文承上条，进一步论述发汗“太过”形成阳绝于里的病机。

“阳脉实，因发其汗出多者，亦为太过”，应与上条“汗出多者，为太过”联系起来看。阳脉微而汗出少者，为自和，此阳脉实而因发汗过多的，也为“太过”。在正常情况下，人体阴阳应该在不停地运动中维持着协调平衡。若阴阳发生偏盛偏衰，不能相互协调平衡，就要发生疾病。此证因汗出过多，伤了胃中水谷津液，使胃之阳气独盛于里，阴液不能与阳气和合以发挥其滋润调节的作用，因而导致大便必硬。此即所谓“太过为阳绝于里，亡津液，大便因鞅也”，绝者，阻绝不通的意思。阳热盛极，胃肠津伤，以致大便硬，因而形成阳明燥实证。

陈修园在深入研究《伤寒论》的基础上，提出治病要严守“保胃气，存津液”这一法则，看来是很有道理的。以上两条，皆由于发汗太多，内伤津液而才转属阳明，具体地证实了这一点。

脉浮而芤，浮为阳，芤为阴，浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝。（259）

【解析】本条以脉论述阳气独盛于内，阴液不足，而致大便硬的病机。

脉浮为阳气盛，故曰“浮为阳”。芤为浮大中空，按如葱管，主阴血虚，故曰“芤为阴”。“脉浮而芤”，是阳热有余而阴液不足的脉象。阳热有余，独盛于内，则胃气生热；阳盛灼阴，阴液亏耗，不能和阳，则阳愈亢而阻绝于里。胃热阳绝，阴不济阳而化燥，势必导致大肠失润而大便硬结。

趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则难，其脾为约，麻仁丸主之。（260）

麻仁丸方：

麻子仁二升 芍药半斤 枳实半斤，炙 大黄一斤，去皮 厚朴一斤，炙，

去皮 杏仁一斤，去皮尖，熬，别作脂

上六味，为末，炼蜜为丸，桐子大，饮服十丸，日三服，渐加，以知为度。

【解析】本条论述脾约证的病机、脉证及治疗。

趺阳脉，即足背动脉，属足阳明胃经，以候脾胃后天之气。“趺阳脉浮而涩”，浮主阳盛，涩主阴虚，见于趺阳部位，则浮为胃阳亢盛，涩主脾阴不足。脾胃相表里，胃为水谷之海，主受纳腐熟；脾主运化转输水谷精微，“脾与胃以膜相连耳，而能为之行其津液”（《素问·太阴阳明论》）。今胃强脾弱，强阳煎灼弱阴，使脾之功能受了约束，不能为胃行其津液，以致津液偏渗膀胱而“小便数”；不能还于胃中以滋润大肠，而“大便则难”，此即“浮涩相搏，其脾为约”。脾约本于胃燥，而小便愈多，津液愈伤，脾阴愈弱，则胃燥愈甚，如此形成恶性循环。脾约证以大便难为主要临床表现，这种大便难，具有以下特点：经常性、习惯性大便秘结，其粪块异常干硬。虽数日不大便，但无所苦，即不见潮热、谵语、腹满痛等证。

综上所述，可知脾约有两个意思：一，约者，穷乏也。津液素亏，脾无津液输布而穷约。二，约者，约束也。脾之弱阴被胃之强阳所约束，津液不能还于胃中。脾约之证，治以麻仁丸润下通便。

麻仁丸即小承气汤加麻子仁、杏仁、芍药而成。方用小承气汤以泻胃气之强，加芍药以滋养脾阴，麻仁、杏仁为滑利滋润之品，可润肠以通便，又杏仁可利肺气，以助胃气的通导下降。以蜜为丸，取其缓缓润下之意。其服法采用渐加法，即初服梧桐子大者十丸，日三次，如不下，每次服用量可渐加至十一丸、十二丸、十三丸……等，直至大便变软，易于排出即可。此即所谓“渐加，以知为度”。

麻仁丸治疗习惯性便秘效果很好，其人因便秘而伴有的烦躁、口臭、头晕、寐差等证，亦可随大便之润下而得到相应地缓解或治愈。

曾治一男性患者刘某，终年嘴唇干裂起皮，常以舌舔润而干裂愈甚，唇皮增厚如痂，痛苦异常，服多种泻火药无效。大便经常秘结难通，然却无所苦。遂断为脾约证。唇为脾之外候，唇干裂起皮，正是脾阴不足之象。遂治以麻仁丸，大便因而逐渐通利，而口唇干裂之证也渐愈。

从以上介绍的内容可以看出，阳明病不大便可有两种病变和两种证候反映：一是以燥热邪气致病为主，其表现既有“身热，汗自出，不恶寒，反恶热”等阳明外证，又有腹满痛或绕脐痛拒按等阳明里证。二是

脾胃阴阳不能自和而致病，脾阴不足，不能为胃行其津液，但其既不见外证，亦不见腹满痛拒按、绕脐痛等里证。前者为胃家实，应以承气汤泻下；后者为脾约，当用麻仁丸润下。以上第257条至260条，讲的即是脾约证。它们从胃强脾弱，阴液亏虚的角度，充实了阳明病的辨证内容，故有重要的鉴别意义和临床意义。

太阳病，根据其不同的证候和病机特点，分别采用麻黄汤、桂枝汤、葛根汤、大青龙汤、小青龙汤、桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤等不同的汗法，以解决不同的表证。阳明病，也同样根据其不同的证候和病机特点，而施用不同的下法：如大承气汤之峻下、小承气汤之缓下、调胃承气汤之和下、麻仁丸之润下，以及猪胆汁、土瓜根、蜜煎导之导下，用以解决不同情况的大便不下。因此，学习“阳明病篇”，解决胃家实证，应有全局观念，只有明确辨证与鉴别，才能恰如其分地使用不同的下法，以解决各种不同类型的阳明里实证。

太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。（261）

【解析】本条论述太阳病汗后转属阳明的证治。

“太阳病三日”，言其病由太阳病发展而来。“发汗不解”，并非指表证未罢，而是指病邪未除而向里传变。“蒸蒸发热者，属胃也”，说明病已由太阳之表转属阳明胃腑之里。里热蒸腾，必致腠理开而汗出濈濈然。这里仅举蒸蒸发热作为阳明典型证候而代表其他诸证，并以此区别于太阳之发热恶寒和少阳之往来寒热。由于里热伤津，发汗又伤津，故本证以阳明燥实为主；加之病属燥热初结，尚未达到发潮热，腹满疼痛拒按的严重程度，故治以调胃承气汤软坚润燥，泄热和胃。

伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。（262）

【解析】本条论述太阳病吐后转属阳明的证治。

伤寒，为太阳表证，不当吐而用了吐法。吐法本用以治疗上焦痰食邪气的，但由于呕吐可以使人身之气向上向外，因而它具有一定的发汗解表作用。伤寒吐后，表证虽解，但胃的气液受伤，邪气内陷而化热，津伤化燥而成实，燥实阻滞，阳明腑气不通，则大便秘结而腹胀满。此腹胀满，乃因燥实而致，故其治仍以调胃承气汤和胃润燥。燥实去则腑气通，腑气通则腹胀除。

以上两条，从蒸蒸发热和腹胀满的内外证候，反映并概括了调胃承气汤证的特点。由于此调胃承气汤证来自于太阳病汗吐后津伤化燥，初结阳明，病情还没有达到痞、满、燥、实、坚俱备的程度，故其治不用

大承气汤，而用调胃承气汤，从这个意义上讲，调胃承气汤证又可看做是胃家实的一个轻证，而带有正气不足的一面。

太阳病，若吐、若下、若发汗，微烦，小便数，大便因鞅者，与小承气汤和之愈。（263）

【解析】本条论述太阳病误治而形成里热便硬的小承气汤证。

太阳表证，当发汗解表，妄用吐下，是为误治；先吐下而后再汗，是为治疗失序，其结果必致邪不解而内陷。若内陷胸膈，见烦热，心中懊憹，属栀子豉汤证，二便多无改变。今吐、下、发汗后，病人出现了微烦、小便数、大便硬等证，说明邪热内陷阳明，形成了阳明腑实证。误治津伤，表邪入里化热，其势尚轻浅，故见微烦；热迫津液偏渗于膀胱，不能还于胃中，所以小便频数而多，大便干结而硬。本证以气滞热结为主，尚未达到谵语、潮热、手足濇然汗出等燥屎结实的程度，且在汗、吐、下后正气受伤，故不宜大承气汤峻下，只可以小承气汤泄热通便，使胃肠气机得以调和通畅则病可愈。故曰：“与小承气汤和之愈”。

得病二三日，脉弱，无太阳柴胡证，烦躁，心下鞅，至四五日，虽能食，以小承气汤少少与，微和之，令小安，至六日，与承气汤一升。若不大便六七日，小便少者，虽不能食，但初头鞅，后必溏，未定成鞅，攻之必溏，须小便利，屎定鞅，乃可攻之，宜大承气汤。

（264）

【解析】本条再论大小承气汤的使用方法及其辨证要点。

“得病二三日”，这里的“病”泛指疾病，确切地说指外感热病。“脉弱”，是对脉紧而言，紧变缓相对地叫“脉弱”。从太阳病上篇“脉微弱，此无阳也，不可发汗”之文可以看出，脉微弱是脉由紧而变弱，反映了寒邪化热而已入里。“无太阳柴胡证”，指既无太阳表证，也无小柴胡汤的半表半里证。“烦躁”，是里有热；“心下鞅”，是胃脘部硬满，乃阳明里实，胃气不和之证。“至四五日”，烦躁心下硬满仍不缓解，言外之意，当有不大便一证，若反不能食，腹满疼痛拒按，脉沉紧，是燥屎已成，腑气不通；今能食，心下硬而脉弱，说明阳明病势轻浅，不耐峻下攻伐，只能“以小承气汤少少与”，以微和胃气。小承气汤的服法是煮取一升二合，分温二服。故“少少与”，则一次只服三五合，而不超过六合，以微和胃气，使烦躁小安。若服药后至六日仍不见大便，则须加大药量，当“与承气汤一升”（仍指小承气汤），则大便可下。

至于对不大便六七日，小便少者，虽不能食，亦不能即断为大承气汤的可下之证。因为小便少，说明津液尚能还入胃中，故知大便“未定

成鞭”，或“但初头鞭，后必溏”。大便不硬，燥屎未成，则不可攻之。若误用攻下之法，必伤脾胃之气，以致运化失职，水谷不别而溏泄不止，故曰“攻之必溏”。“须小便利”，即待到小便数多而通利，方知津液偏渗而燥屎已经形成，此时才可予大承气汤攻下。

以上诸条文，启发医者临诊时既要胆大，又要心细，特别是使用下法，何时峻下，何时和下，更要细心观察鉴别，而一旦掌握了病情，就应不失时机地给予恰当治疗。下面将要介绍的三条阳明急下证，后世称“阳明三急下证”，就是在正确辨证的基础上，谨守病机，采取积极主动的治疗措施，用大承气汤泻下阳明燥热，以存阴液于未亡的方法。

伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也。急下之，宜大承气汤。（265）

【解析】本条论述阳明燥热下劫肝肾之阴的证候及急下存阴的意义。

“伤寒六七日”，言其发病过程已久。“目中不了了，睛不和”，是指肝肾之阴被燥热劫夺的证候。“了了”，分明之意，“目中不了了”，即视物不分明，此为病人自觉症状。“睛不和”，即两目呆滞，瞳子不能瞬动，乃为他觉症状。由于肝开窍于目，目得血而能视，肝阴被劫，不能上注于目，故视物不清。瞳子为肾所主，肾水不足，不能上注于睛，故致睛不调和。“目中不了了，睛不和”，本属肝肾真阴虚损之证。但其人“大便难”而不通，身又有微热，说明里热深伏而腑气不通，故曰“此为实也”。张仲景此处以“大便难”、“身微热”，画龙点睛地指出“目中不了了，睛不和”之证，缘于阳明燥热之实。此时虽然只见大便难、身微热，而不见典型的阳明里证和外证，（如潮热、谵语、腹满痛拒按、手足濇然汗出等）所以叫“无表里证”，但是“目中不了了，睛不和”的真阴欲竭之象已见。说明真阴危亡立待，症情危重，法当急下以存阴，而不能徘徊犹豫。

《伤寒论》总的治疗法则是保胃气，存津液。其中存津液有两个方面的含义：一是发汗、吐、下是祛邪外出的方法，但在使用过程中，一定要注意祛邪而不伤正。太阳病汗法，有“遍身^{𦵏𦵏}，微似有汗者益佳，不可令如水流漓”的要求，就是为了保护阳气、阴液不受损伤。二即用大承气汤急下存阴，也是保存津液的一个方面。燥热太甚，必然下劫肝肾之阴，要想保阴，必须急下，把肠中燥热驱逐体外，才能保住下焦阴水不涸。可见存津液不仅是治疗方法问题，也是治疗的出发点和目的问题。因阳明燥热而致阴精枯竭，正气大伤，若能及时用大承气汤攻下燥屎，犹如釜底抽薪，既能祛除邪气，又保护了阴液，这就是急下存

阴的方法及意义。

选《经方实验录》急下存阴医案一则：

“予尝诊江阴街肉庄吴姓妇人，病起已六七日，壮热，头汗出，脉大，便闭，七日未行，身不发黄，胸不结，腹不胀满，惟满头剧痛，不言语，眼张，瞳神不能瞬，人过其前，亦不能辨，证颇危重。余曰：目中不了了，睛不和，燥热上冲，此阳明篇三急下证之第一证也。不速治，病不可为矣。于是遂书大承气汤方与之：

大黄四钱，枳实三钱，川朴一钱，芒硝三钱。并嘱其家人速煎服之，竟一剂而愈。盖阳明燥气上冲巅顶，故头汗出，满头剧痛，神识不清，目不辨人，其势危在顷刻。今一剂而下，亦如釜底抽薪，泄去胃热，胃热一平，则上冲燥气因下无所继，随之俱下，故头目清明，病遂霍然。非若有宿食积滞，腹胀而痛，壮热^证语，必经数剂方能奏效，此缓急之所由分。是故无形之气与有形之积，宜加辨别，方不致临诊茫然也。”

一般注家认为，目中不了了，睛不和，是燥热灼伤肝肾之阴，阴精不能上注于目所致。但《经方实验录》作者曹家达却认为是阳明燥热之气上冲头目的结果，还指出头痛与头汗出，也与目中不了了、睛不和的病机一致，均是阳明燥热上攻的反映。曹氏以燥热上攻阐发了急下证的病机，并补充了急下证的脉证，对学习本条和指导临床，很有参考价值。

阳明病，发热，汗多者，急下之，宜大承气汤。（266）

【解析】本条论述阳明燥热外逼，热汗不已，治当急下存阴。

阳明病，这里指胃家实证。发热汗出是阳明里证反映于外的证候，且实热不除，则发热汗出不止。泻下实热，当用大承气汤。对此证提出“急下”的关键在于“汗出多”。汗为人体五液之一，由津液所化生。汗出多，津液被耗而阴伤；阴伤则体内燥热愈盛；燥热愈盛，汗出亦愈多，从而形成发热汗出有不尽不已之势，不仅伤阳明胃液，而且又有内竭少阴真阴之虑。为此，张仲景提醒医者，要“见微知著”，遇有热汗不已者，亦当用大承气汤釜底抽薪，急下以存阴。

程郊倩说：“发热而复汗多，阳气大蒸于外，虑阴液暴亡于中，虽无内实之兼证，宜急下之”。尤在泾又指出：“然必有实满之证，而后可下，不然，则是阳明白虎汤证，宜清而不宜下矣”。程氏的“虽无内实之兼证”，言外之意“汗出多”即是内实之证，尤氏则更明确指出“必有实满之证”。这就告诉我们，所以要用大承气汤急下，还必须见阳明腑实之

证，这一点是十分重要的。

发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。（267）

【解析】本条论述发汗不解，化燥成实的急下存阴之法。

“发汗不解”，非指表不解，乃言其病未解。“腹满痛”，则是里实之证。里实当下，但为何要急下？原因是本证病情变化迅速，燥热邪气嚣张，如不以大承气汤急下，则不足以遏其势，而伤阴之弊在所难免。汗法本为太阳表证而设，若太阳病汗不得法，或阳明热证误用汗法，均可导致病不解。或为表邪迅速入里化热成燥，或为阳明里热不除，津伤化燥，从而形成阳明腑实证。本条“发汗不解”，迅即出现“腹满痛”，足见燥热盛实，传变迅速，故当急下以存阴。若当下不下，坐误时机，一旦循衣摸床、惕而不安、微喘直视等险证从生，此时再行泻下之法，恐为时已晚。因此提示医生，要从疾病的发展趋势中看到其后果，并善于抓住时机，及时采取紧急措施，运用恰当的治疗方法，以达到祛邪扶正的目的。

以上三条，从不同角度举例说明了急下救阴之法。孙思邈说：“胆欲大而心欲小，行欲方而智欲圆”，意思是说，医生治病，不但要小心谨慎，也要有胆有略。张仲景在这一方面给后人作出了很好的示范。论中第264条的先与小承气汤法，表现了他小心谨慎之至；而以上三条的急下存阴证治，又表现了他的胆量与魄力。只有将这种胆大与心小结合起来，才能做到既不保守而又不冒进。

腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。（268）

【解析】本条论述腹满不减当下的证治。

腹满一证，论其标属实，但究其本，则有虚实寒热之异。《金匮要略》有“病者腹满，按之不痛为虚，痛者为实”，“腹满时减，复如故，此为寒”的记载，对腹满的寒热虚实作了很好的鉴别。腹部属太阴、阳明所主，腹部持续地胀满而不减轻，或即使减轻一些，也微不足道，则属阳明腑实而不是太阴脾虚。燥屎内结，腑气不通必兼见大便不通，腹痛拒按等证，其治当用大承气汤攻下。若腹满时减，按之不痛，并见便溏泻利等证，则属太阴脾虚腹满，当治以温运之法。本条“腹满不减，减不足言”，是为辨证眼目，但只凭此证还不能就用大承气汤。应与前面诸条参合，方能全面掌握大承气汤证的辨证要点。

阳明少阳合病，必下利，其脉不负者，顺也；负者，失也，互相克贼，名为负也。脉滑而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。

（269）

【解析】本条论述阳明少阳合病的证治。

凡合病，多为邪气较盛的问题。阳明主胃土，少阳为胆木。少阳与阳明、胆与胃，有木土相乘相克的关系。胃主受纳腐熟，胆主疏泄。胃肠的受纳消化功能，要借助胆的疏泄作用。今阳明少阳合病，邪热盛实，影响胃肠的消化不良，则见下利。阳明之脉本应见实大，少阳之脉本应见弦。若阳明少阳合病下利见阳明实大脉象，是胃气不衰，即为“不负”，其病易愈，故为“顺也”；若见少阳弦脉，是胃气衰，木来乘土，其病进而难愈，故“为负也”。“负者，失也”，言其正气不足，胃气衰败。土虚木乘，是为贼邪，故曰“互相克贼”也。以五行乘侮关系而论，凡属相克而致病者，均称为“贼”。脉滑而数，滑主食，数主热，为阳明有宿食的脉象。若脉不弦，说明木气不盛，土不衰，故为顺，其病易治，下之则愈，宜大承气汤。

《伤寒论》中关于二阳合病而见下利的有三条，即第33条太阳与阳明合病自下利，由于病邪偏重于太阳之表，故用葛根汤治疗；第180条太阳与少阳合病自下利，因病邪偏重于少阳半表半里，故治以黄芩汤；本条为阳明少阳合病见下利，是病邪偏重于阳明之里，所以治用大承气汤。前后三条分析比较，则层次分明。本条之阳明少阳合病，因属阳明有宿食内结，故其下利多属热结旁流，应伴有潮热，腹满疼痛，不欲食，恶闻食臭等证。

病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日，不大便者，有瘀血，宜抵当汤。（270）

【解析】本条论述阳明病的瘀血证治。

“病人无表里证”，是说既无头项强痛而恶寒的太阳表证，也没有谵语、腹满疼痛的阳明里证。而只是发热延续七八日不解，此时应当考虑邪热在里的问题，虽脉见浮数，但因无表证，故为阳脉阳证而主热，仍可用下法以泻其热。“假令已下”，脉浮已去而数脉不解，说明气分之热已除，而血分之热仍在。一般地说，邪热在于胃肠气分，若伤津化燥而成为阳明燥实之证，则其人当不能食，而今却消谷善饥，至六七日仍不大便，则更证明邪热不在阳明气分成为腑实，而是热在血分，与血相搏结，为瘀血之证。其治当用抵当汤泄热破瘀。

此之瘀血证，只概要提及发热、脉数、不大便等临床表现，而尚未能详细具体地阐述其特点，参照前述有关抵当汤证条文，可知瘀血证之屎虽硬，却大便反易，其色必黑。此类病证，用承气汤多不能治愈，有时大便虽下，热却不解，脉数亦不除。并可伴见发狂、喜忘、脉沉结等

证，此与阳明腑实不大便的可下之证，显然有别。至于瘀血发热临床亦恒见之，故本文有其现实的意义。

若脉数不解，而下不止，必协热而便脓血也。（271）

【解析】本条承上文，论述下后的又一变证。

若下后脉数不解，浮脉已去，也说明热离气分而入于血分。邪热下迫，则下利不止；灼伤阴络，迫血下行，则大便脓血。

阳明病属于胃肠之病。阳明为多气多血之经，邪热伤于阳明，有在气分和伤及血分的不同，阳明燥热甚者，是为气分证，如白虎汤、承气汤证即是。伤及血分者，是血分证。又有瘀血与便脓血的不同，如上条和本条所述。

伤寒，发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里，不解故也。以为不可下也，于寒湿中求之。（272）

【解析】本条论述寒湿发黄证治。

本证见“身目为黄”，故属黄疸。黄疸有阳黄、阴黄之分。阳黄是湿热发黄，属实证；阴黄是寒湿发黄，多本虚而标实。湿热内蕴，热不得越，湿不得泄，则可发阳黄。若得汗出，则可使湿热泄越，而不能发黄。今“伤寒，发汗已，身目为黄”，说明其发黄的原因不在于湿热而在于寒湿。寒湿在里，脾阳必虚，发汗则阳随汗泄，使脾阳更虚。寒湿不运而内郁，影响肝胆疏泄不利，胆汁外溢，故发身黄。

阳黄与阴黄虽均为湿邪，但一为胃腑有热，湿与热合；一为脾脏有寒，湿与寒合，病机不同，治法迥异。阳黄即湿热发黄为阳明有热，其治可下；而阴黄即寒湿发黄为太阴脾寒，就不能用攻下之法，治当温中散寒除湿。即所谓“以为不可下也，于寒湿中求之”。论中未提及具体治法，可考虑选用茵陈五苓散，若阳虚较甚者，可选用理中汤加茵陈，甚至选用四逆汤加茵陈。

本条侧重于论述寒湿发黄的病因、病机，而其证候叙述不甚详尽。从其病机推断，并根据临床所见，寒湿发黄一般多伴有脾虚寒湿之证，如畏寒、肢冷、大便溏薄、脉沉迟无力、舌胖而淡嫩等。而其黄色晦暗不泽，则又与湿热发黄鲜明如橘子色明显不同。下文即介绍湿热发黄证治，可与本条对比鉴别。

伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。（273）

【解析】本条论述湿热发黄热结于里的证治。

本条应与第248条联系起来分析。第248条提到湿热发黄，常见头汗出，身无汗，小便不利，渴饮水浆等证，本条又在前证基础上，补充了湿热发黄的色泽及腹满见证。湿热发黄，属阳黄，故黄色鲜明如“橘子色”，这也反映了热大于湿的特点。湿热郁结在里，肠胃之气壅滞不利，故腹微满，或可见大便秘结不爽等证。治以茵陈蒿汤苦寒通泄，清热利湿以退黄疸。

伤寒身黄发热者，栀子蘖皮汤主之。（274）

栀子蘖皮汤：

栀子一十五个 甘草一两 黄蘖二两

上三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。

【解析】本条论述湿热蕴郁三焦以致发黄的证治。

伤寒见身黄、发热，是属湿热熏蒸的阳黄。不见恶寒，知邪不在表；不见腹胀满，渴引水浆，知邪不在里。湿热蕴郁三焦而不能泄越，当见头汗出，身无汗，小便不利，心烦懊恼等证。治用栀子蘖皮汤清利三焦湿热以退黄。

栀子蘖皮汤用栀子清热利湿，栀子质轻，清利之中又有宣透作用，可通三焦、利小便，开湿热凝结，还可除烦热。黄蘖苦寒，清热燥湿以坚阴。甘草炙用，和胃健脾，并制栀子、黄蘖苦寒伤胃之弊。栀子偏于清上焦，泻心火；黄蘖偏于清下焦，泻相火；甘草和中健脾益气而扶中。三药相伍，用于正气偏衰、阴中有伏热而黄疸日久不退的，效果很好。下面仅举一个病例，说明本方的临床应用。

患者为一个10岁男孩，患黄疸性肝炎，病已日久，黄疸指数一直很高。前医曾用过茵陈蒿汤多剂，住院期间也多次用过茵陈、大黄等注射液，效均不佳。症见身目黄染、心烦、便溏，两足发热，睡觉时常伸到被外，舌苔黄。遂投栀子蘖皮汤治之，不数剂则黄退而诸证渐愈。此案说明，凡湿热发黄，用茵陈蒿汤后，黄仍不退，但正气业已渐耗，脾胃之气受损，阴分尚有伏热，如见手足心热、五心烦热等证，用本方治疗很是适宜。有的注家认为，本方不该用甘草而应当用茵陈。其实不然，应该说本方妙就妙在用甘草以扶正气的治法。

伤寒瘀热在里，身必发黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。（275）

麻黄连轺赤小豆汤方：

麻黄二两，去节 赤小豆一升 连轺二两，连翘根也 杏仁四十个，去皮尖
大枣十二枚 生梓白皮一升 生姜二两，切 甘草二两，炙

已上八味，以潦水一斗，先煮麻黄再沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服，半日服尽。

【解析】本条论述湿热发黄而兼表证的治法。

本条叙述过简，当以方测证而补其缺。“伤寒瘀热在里”，言外有寒邪束表，内有湿热蕴郁的意思。表邪不解，使湿热之邪难以外越；湿热内蕴，又阻碍表邪之外解，从而形成了表闭而湿热蕴郁发黄的证候。“身必发黄”，即是指“瘀热在里”熏蒸于外的必然结果。表邪不解，应见发热、恶寒、无汗、头身疼痛、脉浮、身痒等证。湿热在里，心烦懊憹、小便不利等证也在所必见。本证当治以宣散表邪，清利湿热之法，用麻黄连轺赤小豆汤。

麻黄连轺赤小豆汤以麻黄、杏仁、生姜，宣散表邪，以解阳郁之热，兼宣肺利水湿之气。赤小豆清热利湿，兼以活血，善治瘀热。生梓白皮苦寒，亦能清热利湿，若无此药，可用桑白皮或茵陈代。连轺即连翘根，亦可用连翘代，可清透邪热之结。甘草、大枣健脾和中，以顾后天之本。潦水即地上所积雨水，古人称“无根之水”，因其无根味薄，故不助湿气。

本方外能解表散热，内能清热利湿解毒，开鬼门，洁净腑兼而有之，因此用于治疗湿热郁结发黄而表邪不解者，效果甚好。现用于治疗急性黄疸初起，多能取效。同时还可治疗湿热蕴郁所致的其他疾患，如荨麻疹，皮肤瘙痒症等。

以上介绍了阳明湿热发黄的三种证治，即湿热偏结于里，见内实腹满、不大便者，用茵陈蒿汤；偏结于表，兼见寒热、身疼等表证者，用麻黄连轺赤小豆汤；湿热郁阻三焦，不表不里，只见身黄发热者，用栀子蘖皮汤。

【小结】

本篇原文共88条。前11条首先围绕“胃家实”提出了阳明病的病因、病机及主要脉证。随后使用对照比较的方法提出了阳明胃阳不足的寒湿证；阳明之热与太阴之湿相合的湿热发黄证，以与阳明燥热实证互相鉴别。此后又论及阳明可下与不可下的辨证和阳明病的预后问题。在辨证

论治的诸条文中，又论述了风寒之邪伤阳明经表的桂枝汤、麻黄汤的可汗之证；经热作衄证；腕热作烦证；以及热在上焦的栀子豉汤证；热在中焦的白虎加人参汤证；热在下焦的猪苓汤证。在阳明病的可下诸证中，又依腑实的程度不同，分别论述了大承气汤证、小承气汤证、调胃承气汤证，以及脾约证、导下证等。其中还夹叙了阳明虚寒的吴茱萸汤证，和少阳三焦枢机不利、大便不下的小柴胡汤证，以增强辨证论治的效果。其后又论及湿热发黄证治及阳明蓄血的证治。全篇虽以论述阳明里实热证治为主，但由表及里、由寒及热、由燥及湿、由实及虚、由气及血，充分体现了辨证论治的精神和辩证思想的运用。

辨少阳病脉证并治法

【概说】

少阳指足少阳胆及手少阳三焦而言。少阳，为小阳，其抗邪能力远不如太阳与阳明有力。

从部位讲，太阳经走人身之背部，主表；阳明经走人身之胸腹部，主里；少阳经脉行于人身之两侧胁肋部，居于太阳、阳明之夹界，故主半表半里。由于少阳居太阳、阳明之中，外可从太阳之开，内可从阳明之阖，具有表里出入枢轴的作用，故有“少阳主枢”之说。

少阳与厥阴相表里，二者不仅在生理上相互联系，在发病时也常互相影响。少阳病不解，可内传于厥阴；而厥阴病当阳气来复时，邪气亦可外达少阳。

少阳发病，可有原发与续发两种情况：原发病是邪气直接侵犯少阳，论中所谓：“血弱气尽腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下”，讲的即是少阳原发病的病因病机。续发的少阳病是邪气由他经传变而来，如太阳传于少阳；阳明传于少阳；厥阴转出少阳等等。

少阳病证也可概括分为经证与腑证两类：如见耳聋、目赤、头角痛、胸胁苦满等证，则为经证；如见口苦、心烦、喜呕、往来寒热、不欲饮食等证，则属腑证。但少阳经证与腑证常常混在一起出现。在治疗上，也不同于太阳、阳明的经、腑为病分而治之，而是用小柴胡汤一方统治经腑之证为其特点。

由于少阳病，邪在半表半里，故汗之不可，吐之不可，下之亦不可。因汗、吐、下之法既不能治少阳半表半里之邪，又不能疏利少阳经腑之气，反徒伤正气而易生变证，故少阳病乃有汗、吐、下“三禁”之说。

少阳病虽亦属三阳病之一，但本篇所列条文不多，这主要是由于少阳病的有关方证已在“太阳病篇”与“阳明病篇”作过介绍，故不赘述。因此学习本篇应与有关内容相互联系，方能对少阳病的辨证与治疗有一个全面的认识。

少阳之病，口苦、咽干、目眩也。（276）

【解析】本条论述少阳病的提纲证。

“口苦、咽干、目眩”三证，是少阳胆腑有热的表现。少阳之气主升发疏泄，其性喜条达，而恶抑郁。邪犯少阳，升发疏泄的机能发生障碍，其气必郁。气郁则易化火，故出现少阳病的热证。少阳胆腑内藏精汁，其味最苦，今热气迫胆液上溢，必见口苦。凡见口苦，则多为肝胆火郁之证，确有其临床意义。若火热灼伤津液，则可见咽干；若少阳木火之气上扰，则可见头目眩晕。

口苦、咽干、目眩三证，均为病人的自觉症状，它属于少阳腑证的范畴。但据临床所见，凡口苦、咽干、目眩之少阳证，往往还有胸胁苦满、往来寒热、心烦喜呕、默默不欲饮食等证。因此，这三证只能说是少阳病辨证的重点，至于少阳病经证的特点，还必须和在“太阳病篇”的少阳病证结合起来体会，对辨证方为全面。

柯韵伯认为：“口咽目三者，脏腑精气之总窍，与天地之气相通者也，不可谓之表，又不可谓之里，是表之入里，里之出表处，正所谓半表半里也。三者能开能阖，开之可见，阖之不见，恰为枢之象。”他从口咽目的部位及生理功能，论证了少阳主半表半里及主枢的特点，值得我们参考。

少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。（277）

【解析】本条论述少阳病经证的治疗禁忌及误治的变证。

“少阳中风”，即少阳经脉感受风邪。足少阳胆经起于目锐眦，上头角，下耳后，入耳中，下贯胸膈；手少阳三焦经，布膻中，散络心包，下膈。风为阳邪，其性上行，少阳主火，风火循经上扰清窍，故耳聋、目赤；邪阻经脉，经气不利，故“胸中满而烦”。少阳病位在半表半里，非上非下，又无痰、食等有形之实邪，故“不可吐下”。误用吐、下，不仅对少阳之邪起不到治疗作用，反而要伤人的正气。少阳为小阳，本已抗邪力弱，若正气再伤，胆气虚损，其人则心悸而惊。

以经络循行部位为根据而指导临床辨证治疗，是中医学论治的方法之一。后世有的医家用柴胡剂治疗偏头痛、三叉神经痛而取得疗效，其理论根据可能与本文有关。

伤寒，脉弦细，头痛，发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语。此属胃，胃和则愈，胃不和，则烦而悸。（278）

【解析】本条补述了少阳病脉证，并指出少阳病的治禁及误汗后的变证。

关于少阳病的脉象，“太阳病篇”与“阳明病篇”都曾有过论述。

如“太阳病篇”第156条说：“脉细者，此为阳微结”，这里的阳微结，就是少阳病；第105条谓：“阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛者，先与小建中汤；不差者，与小柴胡汤主之”，又提出了少阳病应见弦脉。本条可以说是综合了以上两条的精神，明确指出少阳病的弦细脉象。

伤寒、头痛、发热，本属太阳病证，如果脉浮，则属太阳病无疑。今见脉弦细而不浮，说明病不在太阳，而在少阳，故曰“属少阳”。属者，转属之意。因本为太阳伤寒，而后传入少阳，故不言少阳病，而言“属少阳”。病在表者当发汗，少阳为病邪在半表半里，故曰“不可发汗”。如果误发少阳之汗，必伤胃中津液而成燥；燥热上扰则见谵语，故曰“此属胃”。此证或津液能以自复，则胃燥得润；或少与调胃承气汤微和胃气，使“胃和则愈”。如果津液不能恢复，燥热不解，将进而耗伤阴血。阴血伤则心失所养，故见心烦、心悸之证。

以上两条，都论述了少阳病的治疗禁忌，前条讲少阳病不可吐下，吐下则悸而惊；本条谓少阳病不可发汗，发汗则谵语，甚至发生烦悸之证。《医宗金鉴·伤寒心法要诀》对少阳治禁作了如下归纳：“少阳三禁要详明，汗谵吐下悸而惊，甚则吐下利不止，水浆不入命难生。”金元时期的李东垣又提出少阳病还应有利小便之禁，对少阳治禁又做了进一步的补充。少阳禁汗、吐、下、利小便，是言其常，而在小柴胡汤的和解基础上如兼用汗、下、利小便之法，则又是言其变。治疗少阳病证，如果能做到知常而达变，则就全面地掌握了治疗方法。

本太阳病不解，转入少阳者，胁下鞭满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。（279）

【解析】本条论述太阳病不解，邪传少阳的证治。

本为太阳病，由于治疗不及时或治疗不当，致使邪气转入少阳。“胁下鞭满”，是少阳经气不利的反映；“干呕不能食”，是少阳气郁而胃气不和；“往来寒热”，是正邪交争于半表半里，而互有进退。此时如果未经误治，而脉见沉紧，沉则说明太阳表证已解；紧有弦之意，为少阳之脉，故知病邪已传少阳。因此以小柴胡汤和解少阳则愈。

若已吐、下、发汗、温针，谵语，柴胡汤证罢，此为坏病，知犯何逆，以法治之。（280）

【解析】本条承上文论述少阳误治变证及救治法则。

如果上述情况已经用过吐、下、发汗、温针等法，以致邪离少阳而使“柴胡汤证罢”，证见谵语，说明误治以后已变为坏病。至于具体治疗

方法，则要观察其脉证的变化，而详究其根源，从而制定相应的治疗方法，此即所谓“知犯何逆，以法治之”之理。

以上两条说明了三个问题：①太阳病不解，可自然传变而转入少阳；②误治变证不仅发生于太阳病，也可见于少阳病；③少阳病误治变证多端，很难以一种治法而概括全面，张仲景所谓“知犯何逆，以法治之”，是一个救治的原则。

以下从第281条至第283条，主要说明少阳主枢的临床意义。少阳之气，外合太阳之表，内从阳明之里，其作用如同枢纽。少阳主枢，不但是表里之枢，而且也是阴阳之枢。因此无论是表里同病，或是邪气由阳入阴的过程，都与少阳的枢机作用有关。如何保持少阳枢机和利，使邪气不能由表及里、由阳转阴；以及在三阳合病之时治从少阳，以解合病复杂之邪，以下三条不仅提供了理论根据，而且也有着很重要的临床实践意义。

三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗。（281）

【解析】本条论述以少阳病证为主的三阳合病脉证。

凡言合病，皆指阳经合病，关于三阳合病，前已有论述，如第232条“三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁而面垢，谵语遗尿……若自汗出者，白虎汤主之”的证治，因阳明的热证突出，故治疗专取阳明而用白虎汤。本条三阳合病，从其脉证辨别，则是重点在少阳，故当治以和解之法，使枢机利、表里和，则三阳病解。“脉浮大”，浮为太阳之脉，大为阳明之脉；“上关上”，即浮大之脉在关上部位最明显。仲景脉法称寸脉为“寸口”，关脉为“关上”，尺脉为“尺中”。所谓“上关上”就是说浮大脉象在于关部之上，反映了阳热之邪壅盛为甚。亦有注家认为关脉以候胆，“脉浮大，上关上”，反映少阳经的邪热气盛，此说似亦可以。邪热壅盛若扰于神明，则昏昏而欲眠睡，此之“但欲眠睡”要和少阴病“但欲寐”相区别：三阳合病，但欲眠睡，脉见浮大，上关上，是一派阳热旺盛之象；少阴病，但欲寐，脉见微细，是一派阳衰阴盛之证。二者虽均有但欲眠睡，但寒热殊异，虚实迥别。“目合则汗”，即眼睛闭上就汗出，亦称为盗汗。少阳为半表半里而主枢，关系人体阴阳表里出入之机。目合则阳入于阴，少阳本主相火，阳热内迫，则里热更盛。阳加于阴谓之汗，里热盛而逼津外渗，所以目合则汗。这正是少阳经有邪热的反映。本条所述三阳合病，仍以少阳邪热为重，文中虽未提及治法，根据病情分析当和解少阳之邪，而较为适宜。

曾治一16岁女孩，证见盗汗、口苦、大便干燥、心下憋满、烦躁、月经后期等证，诊为肝胆气火交郁，经用大柴胡汤加丹皮治之而愈。这

说明凡有少阳火郁者，当首选疏肝理气清透火郁之法，即所谓“火郁发之”之义。现常用柴胡清骨散、青蒿鳖甲汤治疗骨蒸劳热、盗汗等证，就说明盗汗一证确有因少阳相火郁勃而致者，在治疗的时候，也只有配合清透少阳之品，如柴胡、青蒿使相火外达，方能切中病情，提高疗效，达到治疗目的。

伤寒六七日，无大热，其人躁烦者，此为阳去入阴故也。（282）

【解析】本条论述病邪由表传里的见证。

伤寒至六七日，而身无大热，说明表邪已去。其人虽身无热而烦躁不安，又反映了“阳去入阴”。阳指表而阴指里，邪已入里，故见烦躁不安之证。然与少阳枢机不利，不能枢转表里之邪有关。同时，邪气由表入里，又常以少阳为通路，因少阳为表里之枢的缘故。由是可见，若少阳枢机不利，由阳入阴，由表入里的病变，则不得实现。

伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪。其人反能食而不呕，此为三阴不受邪也。（283）

【解析】本条论述三阴不受邪的见证，说明少阳为阴阳枢机之理。

“伤寒三日”，仅为举例而言，不必拘泥日数。伤寒病已三日，按一般规律，三阳经已传尽，三阴经当受邪。而三阴受邪，太阴则首当其冲，因为太阴为三阴之始。太阴病应见腹满而吐，食不下等证候。而今“其人反能食而不呕”，表明脾胃之气调和。太阴脾气健旺，则少阴、厥阴亦不会发病，故谓“三阴不受邪也”。

本条的意义在于使人懂得：治疗疾病时，必须注意少阳之气的盛衰。只要少阳之气不衰，即可杜绝邪气入里传入阴经，为此，治疗少阳病，不仅能和解表里，而且能和解阴阳。

伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。（284）

【解析】本条论述少阳病欲愈的脉象。

“伤寒三日”，为假设之词，意指邪气已传少阳。少阳病，当见弦脉。反见脉小者，说明少阳胆热已衰。以脉断病，是小则病退之义。少阳，是为小阳，脉当弦细，如脉见细小而不弦，反映了邪气衰退，正气恢复，是病向愈的征象。所以说：“少阳脉小者，欲已也”。

少阳病，欲解时，从寅至辰上。（285）

【解析】本条论述少阳病欲解的时间。

少阳之气通于春，春建于寅，是阳气生发之始。而少阳得其时则旺，则抗邪有力，故以寅、卯、辰为欲解的时间。

【小结】

本篇共10条。因在“太阳病篇”与“阳明病篇”均已论及，所以本篇除补充了一些少阳经证与腑证外，还强调了少阳病在治疗上的禁忌等法，并举出了误治后的种种变证。最后论述了少阳作为表里之枢与阴阳之枢，在疾病传变与发展过程中的作用与地位，以及预防传变上的重要意义。

辨太阴病脉证并治法

【概说】

太阴病，为三阴病的初始阶段。病由三阳转入太阴，标志着邪气由六腑向五脏发展。

太阴包括手太阴肺和足太阴脾。太阴病以足太阴脾病为主，乃脾家阳虚气弱，寒湿内盛的病证。因为脾阳有运化水谷精微，以营养脏腑器官与四肢百骸的作用。若脾阳虚衰，中阳不运，寒湿不化，即可形成太阴病。因而脾阳虚而寒湿重便为太阴病的两大特点。

太阴病的成因有寒湿邪气直中太阴而发病的，亦有因传经或误治而形成的。如少阳之邪传入太阴或太阳误治伤害脾阳而转属太阴为病。

太阴病的临床表现以腹满时痛、食不下、呕吐、自利益甚等证为主。

太阴病分经证与脏证两类：经证以脉浮、四肢烦疼等证为主，治以桂枝汤解太阴经表之邪。脏证以腹满时痛、自利不渴等脾虚寒证为主，治以温法，可用理中汤、四逆汤等。

除经证与脏证之外，还有一种脾脏本身的气血不和证，此证既不为寒，也不为热，而属脾家自身气血不和，阴阳失调的证候。其表现以腹满疼痛为主，治以桂枝加芍药汤和桂枝加大黄汤，以调和脾家阴阳气血。又太阴湿邪内蕴，常是导致发黄的一个重要因素，故太阴之湿若不能运化而与寒邪或热邪相合，则发为黄疸，这也是太阴病的主要病变之一。

太阴与阳明为表里，脾与胃以膜相连。脾胃升降相因，燥湿相济，以维持正常的生理功能。在发病时，脾胃病变亦常相互影响或互相转化。阳明病，胃病及脾，伤害脾阳，可转为太阴病；太阴病阳复太过，亦可转属阳明，此即“实则阳明，虚则太阴”之义。

太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结鞕。（286）

【解析】本条论述太阴病的提纲证。

太阴病为脾阳虚而有寒湿之邪。寒为阴邪，易伤阳气。脾阳被寒邪所伤，运化失职，寒湿不运，气机滞塞，则腹满时痛。因属虚寒性疼

痛，故时痛时止，得温则减。脾胃虚寒，升降失常，胃气上逆则吐；脾虚气陷，寒湿下注则泻；中焦虚寒，胃不腐熟受纳，脾不健运，因而不能食。所谓“自利”，是指自发的下利，并非被动所成。“自利益甚”的意思，一则强调了在太阴证中下利之证愈来愈重，同时也指出，其他如腹满时痛、食不下诸证，也因自利不止而愈渐加重。这就便于和阳明腑实证的腹满疼痛相鉴别：实证腹满痛、大便燥结，其腹满痛常随大便通畅而减。太阴虚寒腹满痛，并不随下利而减，反因下利愈伤脾阳，寒湿愈盛，气机愈加滞塞而腹满疼痛则愈重。

太阴病本属虚寒，当治以温化。若误以腹满时痛为实，用寒凉药物，必更伤脾阳。阳虚不能制阴，阴寒上逆，则“胸下结鞕”。胸下结硬比心下结硬位置为高，故病情较为严重。

本条论述了太阴病中焦虚寒之证，其主证是腹胀满，自利益甚，呕吐不能食，时腹自痛。

太阴中风，四肢烦疼，阳微阴涩而长者，为欲愈。（287）

【解析】本条论述太阴中风欲愈的脉证。

“太阴中风”，指脾虚之人感受风邪。因脾主四肢，“风淫末疾”，故见“四肢烦疼”，烦疼即疼痛厉害的意思。脉见“阳微阴涩”，是阴证阴脉，若由阴转阳，即由微涩而变为脉长的，说明邪退正复，里气未损，此时虽有腹满而吐，食不下，自利益甚等证，也由于阴证见阳脉，而属欲愈之象。

太阴病欲解时，从亥至丑上。（288）

【解析】本条论述太阴病欲解的时间。

亥、子、丑三时，是阴极而阳生，故为阴阳消长之时。太阴病为阳虚中寒之证，当此之时，得阳气来复之助，故为其欲解最有利的时间和条件。

有的注家认为，脾为阴中之至阴，气旺于亥、子、丑三个时辰，故当此时则病易愈。

太阴病脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。（289）

【解析】本条论述太阴病从外解的治法。

太阴本脉应见弱象，今脉不弱而浮，说明其病由阴转阳，邪气已外达于肌表。邪在表者，当用汗解，故曰“可发汗，宜桂枝汤”。

以上第287条与289条两条，只做了一般的解释，若联系前后条文，结合临床实际来看，这两条在文字上作如下的调整，即“太阴中风，四

肢烦疼，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤”，“太阴病，脉阳微阴涩而长者，为欲愈”，如按以上修改则对于病情理解更为贴切。

前条讲的是太阴经证的脉证与治法。因风邪伤于太阴经表，故见脉浮、四肢烦疼。治以桂枝汤既能解肌发表，又能调和脾胃，且去邪而不伤正，又寓有建中之意，故用于太阴脾虚而患中风证者最为适宜。

后条则论太阴病欲愈之脉象，解见前。

自利不渴者，属太阴，以其藏有寒故也。当温之，宜服四逆辈。
（290）

【解析】本条论述太阴虚寒下利的证治。

三阴病皆有利一证，须分析病属何经下利。“自利不渴者，属太阴，以其藏有寒故也”，即指出了太阴虚寒下利的病机及辨证要点。太阴脾虚，寒湿不化，清气下陷，则自利为甚；寒湿盛于里，故口不渴。若少阴虚寒下利，由于肾阳虚衰，气化不利，津液不能蒸腾，故见自利而渴。可见渴与不渴对诊断少阴下利还是太阴下利，则有重要鉴别意义。

太阴下利既属脾脏虚寒，所以治疗当用温法，可服四逆汤一类的温热剂，即所谓“当温之，宜服四逆辈”。此处为何不提出具体方药，而用“四逆辈”来概括呢？这是因为中焦虚寒下利与下焦虚寒下利不是不可逾越的。中焦下利严重到一定程度，即由脾阳虚而发展到肾阳虚时，则会形成下焦下利。中焦虚寒下利，可服理中汤；若利久不愈，发展到下焦虚寒下利时，就必须用四逆汤来治疗。作者在此概括地指出“服四逆辈”，示人要根据病情的变化，选用温脾或脾肾双温的方药。后世医家制附子理中丸治疗脾肾阳虚的下利，就是据此理论而来。

若为中焦虚寒下利而选用理中汤时，可根据病情作如下化裁：如下利且伴吐甚者，为胃寒气逆，可加丁香、吴茱萸，为丁萸理中汤；如下利且伴腰痛、肢重者，为寒湿较盛，可加苍术、附子，为苍附理中汤；如下利且伴小便不利者，为湿邪蕴郁，可加茯苓、泽泻，为苓泻理中汤。临床灵活化裁，每可取效。理中汤方，见《辨霍乱病脉证并治法》篇。

伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴。太阴当发身黄；若小便自利者，不能发黄。至七八日，虽暴烦，下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。**（291）**

【解析】本条论述太阴病的两种转归：一为湿郁发黄，二为脾阳来复，易邪却病去。

本条应和“太阳病篇”第199条联系对比分析。两条皆论太阴病发黄证，其不同点是：第199条是湿邪去，热从燥化而成阳明病；本条是脾阳来复，以致暴烦下利而作解。

伤寒脉紧而变缓，意味着寒邪化热。“手足自温”，即手脚发热，为太阴发热的特征。因脾主四肢，所以太阴发热只见于手足而与阳经发热遍及周身不同。太阴有热，或是热与湿合而发黄；或是病情自愈而作解。太阴脾虚，水湿内生，邪热入里与湿相合。若见无汗、小便不利者，则湿热不能泄越而“身当发黄”。如小便自利，表明湿有出路，故“不能发黄”。至七八日，若病人突然发烦，并下利日十余次而必能自止，这是脾阳恢复，祛邪外出，病证向愈的佳兆。脾气充实，腐秽之邪就不能留于肠中，所以才发生下利。正气恢复，能与邪相争则烦。暴烦，下利日十余行，表面看似属病情加重，但实质是正气恢复祛邪外出的一种形式，与三阳经病正胜邪却而出现“战汗”作解的形式不同，而机理则是一致的。

太阴脾虚有寒的下利与正胜邪却的暴烦、下利，证虽有近似之处，但病机却迥然不同：太阴虚寒下利为脾虚气陷，运化无力，寒湿下注，表现为下利溏薄，自利益甚；太阴阳复下利则是正胜邪却，故其下利多腐秽之物，且下利多能自止，诸证也随之自愈。

本太阳病，医反下之，因而腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。（292）

桂枝加芍药汤方：

于桂枝汤方内，更加芍药三两，随前共六两，余依桂枝汤法。

【解析】本条论述太阴脾家气血阴阳不和的证治。

太阳病，不当下而下，故曰“反”。误下太阳，虚其里气，邪气因入，而见腹满时痛，故曰“属太阴也”。若属太阴虚寒，寒湿内阻，升降失常的证候，则应见吐利。而今不见吐利，只见腹满时痛，说明非为阳虚寒湿之证，而是太阴脾脏气血阴阳不和，肝木乘土之证。脾不和而气壅滞则腹满，血不和而脉拘急则腹痛。且土虚木乘，疏泄不利，气机滞塞，也是形成腹满时痛的原因之一。治以桂枝加芍药汤，调和气血阴阳，缓急止痛为法。

桂枝加芍药汤即桂枝汤倍用芍药。对于本方的治疗作用，历代注家

见解不一。有的认为本方证仍是太阳病未解，又因误下邪陷而兼有太阴证，所以用桂枝汤以解外，加芍药和中缓急以治腹痛。然从本方药味配伍和从病情变化看，此说难以成立。因为方中桂枝仅用三两，而芍药用六两，芍药为血分药，其量倍于桂枝，必然制约桂枝的解表作用，可见本方并不为解表而设。本证的特点，在于“腹满时痛”，此种“腹满时痛”既和阳明病的“腹满不减，减不足言”有别，又和脾寒的腹满、下利之太阴证也不同。它属于脾家气血阴阳不和之证。由此可见，脾本身气血不和所致之腹满时痛，非寒非热，故理中、四逆、承气等方均非所宜，应以调和气血阴阳的桂枝加芍药汤最为贴切。

本方以桂枝汤调脾脏气血阴阳，加芍药既能益脾阴、和脾血，又能于土中伐木，缓急以止痛。临床凡见腹满时痛，脉弦细，舌质偏红，苔薄白等证者，多属脾家气血阴阳不和，选用本方治疗，每能取效。

本方较小建中汤少一味饴糖，其病机也较近似，只是本方证程度稍轻一些。如果病情进一步发展，脾气更虚，出现腹痛、心悸、面色苍白、脉来无力等证，就要选用小建中汤了。至于发汗后，腹胀满者，属于脾虚、湿阻、气滞，尚未及血分，应以厚朴生姜半夏甘草人参汤益脾除湿、化痰利气，临证时当注意上述诸方证的鉴别。

大实痛者，桂枝加大黄汤主之。（293）

桂枝加大黄汤方：

桂枝三两，去皮 大黄一两 芍药六两 生姜三两，切 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【解析】本条承上条，论述太阴之邪外薄阳明的证治。

“大实痛”，是针对上条“腹满时痛”而言。含有两个意思：一是“大”，形容势重，即腹满疼痛俱甚；二是“实”，指有实邪，不是单纯的气血不和，而兼有阳明之实，其证当见腹痛拒按，大便不通。阳明与太阴相表里，太阴脾脏受邪，邪气外薄阳明，使阳明腑气不利，所以腹部大实痛。治以桂枝加大黄汤调和太阴气血，兼泻阳明瘀滞。

桂枝加大黄汤即桂枝加芍药汤再加大黄，本方既可调脾脏气血，又可化瘀滞、以泄胃家之实，用于太阴病腹痛，大便不利，较为适宜。

太阴为病脉弱，其人续自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以

其人胃气弱，易动故也。（294）

【解析】本条承上条，论述脾胃气弱当慎用寒凉药物。

太阴病脉弱，是脾胃气虚之象，清阳不升而下陷，则“其人续自便利”，即初起虽未见便利，尔后亦必将泻利。此时假若见腹满时痛，甚或大实痛之证，而需用大黄、芍药者，则“宜减之”。“宜减之”，注家有两种解释：一是减少大黄、芍药的用量；二是减去此二药，也有人认为只去大黄。解释虽有不同，但有一个共同的原则与法度，即太阴病见弱脉为中阳不足之证，大黄、芍药为寒凉药物，不当用而用，必更伤脾胃之阳，故应慎用或不用。“以其人胃气弱，易动故也”，是自注句，指出脾胃气弱，不耐寒凉攻伐而易于伤动，以致发生泄利不止的坏证。

【小结】

本篇仅有原文9条，较易理解。主要论述了太阴中阳不足，虚寒下利证；太阴经证；太阴湿热发黄证；太阴阳复邪却，暴烦下利自愈证。较难理解的是太阴脾家本身气血不和的腹满时痛证和太阴气血不利外薄阳明的大实痛证。

太阴虚寒下利，治用理中四逆辈，为太阴病正治之法。经证宜汗，治以桂枝汤。气血不和宜调和气血，治以桂枝加芍药汤。太阴外薄阳明，则宜以桂枝加大黄汤治之。

辨少阴病脉证并治法

【概说】

少阴包括手少阴心和足少阴肾，少阴病也就是心肾的疾患。

少阴司水火，为人体阴阳之根，先天真气之所系。心火居上，肾水在下，心肾借经脉之连属，使水火上下交通既济，以维持人体的阴阳平衡。病至少阴，则心肾机能受损，阴阳失去平衡。火衰者，表现为阳虚寒证；水亏者，表现为阴虚热证，若阴阳虚极而离决，则可出现精气竭绝的死证。

少阴病有原发与续发两类。原发少阴病，为寒邪直中少阴；续发少阴病为传经之邪或误治伤阴阳之气而成。原发的少阴病，多见于年高体弱或体阳素虚之人，由于抗邪无力，寒邪可不经太阳而直中少阴，证情险恶，故有“老怕伤寒”的警句。续发的少阴病，或因太阴虚寒下利，日久伤及肾阳而邪传少阴；或因太阳与少阴相表里，当少阴阳气不足，抗邪无力之时，则太阳之邪每易内犯少阴之本而形成少阴病。

少阴病，以脉微细，但欲寐为主要临床表现。其病变根据阴阳偏盛偏衰的不同而分为寒化证与热化证两大类。阳虚寒化证，是少阴的本证，亦为少阴的主要病变。由于足少阴肾为水脏，少阴阳虚则不能气化津液，故少阴寒化证又常兼有水气泛滥的证候。至于少阴病的热化证，是因手少阴心为火脏，若少阴的阴水不足，则心火无制，而可发生阳盛阴虚的各种热证。

少阴病治法，若属阳虚阴盛的寒化证，则应扶阳以抑阴，有水者，当兼以祛寒利水；若属阴虚阳亢的热化证，则治以育阴为主，有火者当兼以清火。由于少阴病以阳虚为主，且多有亡阳之变，所以在治疗时，要积极主动，采取措施，以免贻误病情，造成严重后果。

少阴阳虚寒化证，以阳气存亡而判断预后与转归。若见恶寒，身蜷，手足厥冷不回者，则为病进；若更见下利不止，脉不至者，则属病危。若见手足温，欲去衣被等证，表示阳气来复，则是病情向愈的好现象。

少阴之为病，脉微细，但欲寐也。（295）

【解析】本条论述少阴病的提纲。

少阴病，以“脉微细，但欲寐”，即一脉一证作为辨证要点，揭示了其阴阳俱虚而以阳虚为主的病理变化。脉微主阳虚，脉细主阴虚，脉微细则主少阴阴阳皆虚。然“微”在前而“细”在后，则含有以阳虚为主的含义。“但欲寐”一证，形容病人似睡非睡，精神萎靡不振的状态。在正常生理状态下，卫气行阳则寤，行阴则寐。昼夜之中，卫气行于阴、阳各二十五度，故健康人有寐有寤。神是人体生命活动的外在表现。“精”与“神”相互为用，精气则是神的物质基础。精气充实，则神自然充沛；精气不足，则神气萎靡而衰败。少阴为病，阴阳皆虚，精气不足，反为邪困，故其人精神不振，昼夜皆昏沉萎靡，欲睡而又不能成寐，即所谓“但欲寐”。少阴病脉证提纲，以“但欲寐”概括其他见证，突出了精神萎靡症状的重要性。并提示医者，临证时如见到病人出现整日昏沉萎靡，似睡非睡，呼之精神略振，须臾又合目思睡等一派阳气不足的证候，即应采取积极治疗措施。

少阴病，欲吐不吐，心烦，但欲寐，五六日，自利而渴者，属少阴也，虚故引水自救。若小便色白者，少阴病形悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。（296）

【解析】本条论述少阴病阳虚水火不济的证候。

少阴病，本为阳虚阴盛。今见“欲吐不吐，心烦”等证，似属有热，而审视其小便色白，故知当属少阴虚寒无疑。在此辨小便颜色却起到了辨证的关键作用。

少阴受邪之初，尚有一定抗邪能力，正邪相争而少阴气馁，欲受不甘，欲却而又不能，故见“欲吐不吐，心烦”等证。阳气虚又被寒邪所困，精气不足，阴气用事，所以其人“但欲寐”。此时少阴虚寒主证已见，当用急温之法，扶阳以消阴。但医者被“欲吐不吐，心烦”等证所惑，不明寒热真假而观望拖延，至五六日后，则阳气更虚，阴寒更盛，从而出现了“自利而渴”的证候。肾阳虚衰，不能温脾暖土，故自下利；不能蒸化津液以上承，故又口渴。由于“自利而渴”是下焦肾阳虚衰所致，故曰“属少阴也”。津不上承，口中津液匮乏，而欲引水自救，但必喜热饮，且饮量不多。

从以上欲吐不吐，心烦，但欲寐，自利而渴，欲引水自救等证，已确认病在少阴，似无可怀疑，但属寒属热，尚不能定论，此时张仲景又进一步提出了辨少阴病虚寒证的关键，即“若小便色白者，少阴病形悉具”。由于小便色白，是肾阳虚不能温化水液的见证，即所谓“以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也”，所以小便色白不黄，对确诊少阴阳虚寒化证有着重要的辨证意义。

病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也，此属少阴，法当咽痛，而复吐利。（297）

【解析】本条论述寒盛亡阳的脉证。

“脉阴阳俱紧”，即尺寸脉皆紧，为太阳伤寒脉象。紧脉主寒、主实，本应无汗，而反见汗出者，是寒盛伤阳，阳气外亡，不能固表的征象，故其病已不属太阳，而“属少阴”。太阳与少阴为表里，少阴阳气充实，则卫外有力，太阳表邪不能内传。若寒邪盛于表，而里阳不足，则太阳表寒可乘虚飞渡少阴。阴寒内盛，逼迫阳气外亡，则形成少阴寒盛的亡阳证。少阴寒盛亡阳，与少阴阳衰阴盛亡阳有所不同，前者寒盛，其脉多见紧；后者阳衰，其脉多见微。当然，阳虚必致阴盛，而寒盛伤阳又必致阳虚，二者互为因果，只是病变各有侧重而已。

少阴经脉循喉咙，少阴肾为胃之关，又主司二阴。故当少阴感寒，寒邪直入，经脏俱病，则“法当咽痛，而复吐利”。

少阴病，咳而下利^譌语者，被火气劫故也，小便必难，以强责少阴汗也。（298）

【解析】本条论述火劫伤阴证，与上条寒盛亡阳相对应。

少阴病见咳而下利，本为阳虚寒盛之证，寒邪上逆于肺则作咳，下迫于肠则下利，治应以四逆汤之类温脏祛寒。若误以火劫发汗，则可发生^譌语及小便难之坏证。火劫，是以火疗强迫发汗的方法，少阴病本阴阳俱虚，本无作汗的物质基础，如果再用火疗以劫汗，则必导致火热伤阴，而出现小便难；火邪内迫，胃燥津伤，则见^譌语。由于诸变证的发生皆因少阴被火劫汗之过，故曰：“以强责少阴汗也”。

少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。（299）

【解析】本条论述少阴病阴虚者不可发汗。

本条只举脉象，并未明言证候。但指出病为在里，联系细主阴虚，数为有热，当辨为少阴之脏阴虚有热。以脉测证，此证可由于阴虚于内不能制阳于外而见发热。其治当壮水之主以制阳光，不可误为表热而用发汗之法。误汗则津液更伤，阴愈虚而热愈炽。

少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。（300）

【解析】本条论述少阴病阳虚者不可发汗，阴阳俱虚者又不可攻下。

微脉，是极细极弱，似有似无之脉，主阳气大虚。少阴病见脉微，说明心肾阳气虚衰。少阴真阳为一身阳气之根，误发少阴阳虚之汗，则有亡阳之变，故曰“少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也”。

尺脉候里，候肾。“尺脉弱涩”，即尺脉涩而无力。脉涩有力，多主邪阻血瘀；脉涩而无力，则为阴血亏虚，不能充盈脉道。“阳已虚，尺脉弱涩者”，是言其人不仅阳虚，而且阴也虚，故其治法不仅不能发汗，而且也不能因阴虚血少，大肠失润见不大便，而用攻下的方法治疗。因发汗则亡其阳，泻下则竭其阴，故汗、下均应禁忌。

以上两条揭示了少阴病的病变实质在于正气虚损。其脉细沉数，主阴虚，不可发汗；脉微主阳虚，亦不可发汗。因为汗是阳气蒸化津液而成，发虚人之汗，不仅伤阴而且伤阳。而少阴病属阴阳俱虚者，则不仅不能发汗，而且也不能泻下。

在此设少阴禁汗、禁下两条，则为后文太少两感之可汗，阳明燥热灼伤少阴阴液之可下埋下了伏笔。

少阴病脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦下利，必自愈。（301）

【解析】本条论述少阴病寒去阳回自愈的脉证。

脉紧，本主寒。太阳病脉紧，是寒邪伤表，应见发热、恶寒、无汗等风寒表实证。“少阴病脉紧”，为寒邪中于里，当见无热恶寒，手足厥逆。“至七八日”，是正邪相持阶段，如发生“自下利”之证，就有正胜邪却或邪胜正负这两个方面的机转。此时如果出现“脉暴微，手足反温，脉紧反去”的情况，则是阳复寒退之象。“脉暴微”，是指脉突然不紧了。少阴病，本为手足厥冷，而今却见手足温，故称“反”。“脉紧反去”，表明邪气已退，正气已复，其病向愈，故“为欲解也”。此时虽见心烦，下利，亦必自愈。因为烦是阳气恢复，能与邪气斗争的表现；下利则是正胜驱邪外出的反映。这与第291条太阴病“虽暴烦，下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也”的意义相同。

少阴病，下利，若利自止，恶寒而蜷卧，手足温者，可治。（302）

【解析】本条论述少阴病阳气来复，手足变温的可治之证。

少阴病虚寒下利，多见恶寒而蜷卧，说明阳气极虚而阴寒极盛。此时下利若能自止，手足逐渐转温，则是阳气来复的佳兆。四肢为诸阳之本，最能反映阳气的盛衰。手足温，说明阳气已复，四末得温，而且阳气已能够战胜寒邪，故“利自止”。阴寒重证，阳复则生，故为可治，预

后较好。虽为可治，但不等于不药而自愈，仍应据情选用四逆汤、白通汤等法救治。

少阴病，恶寒而蜷，时自烦，欲去衣被者可治。（303）

【解析】本条论述少阴病阳气来复，烦热欲去衣被的可治之证。

少阴病“恶寒而蜷”为阳衰阴盛之证。若其人渐见“时自烦”，即有烦热感而想去掉衣被的证候，亦说明是阳气恢复，能与邪争的佳兆，故谓“可治”。

少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈。（304）

【解析】本条论述少阴病欲愈的脉象。

这里的“阳”与“阴”，指寸脉与尺脉而言。风为阳邪，少阴中风，寸脉应浮。今不见浮，反而见微，说明邪气不盛。少阴病，主里虚，尺脉应沉。今不沉，反而见浮，是为阳气得复之象。脉阳微而阴浮，反映了正胜而邪衰，故“为欲愈”。

少阴病欲解时，从子至寅上。（305）

【解析】本条论述少阴病欲解的时机。

少阴病为阴盛阳衰之证，故当得阳助之时，便为欲解之机。子、丑、寅三个时辰，是一日之中阳气的始生之时，因此，少阴病在此时由于能得阳气相助，便是其病欲解的最有利的时机。

少阴病，吐利，手足不逆冷，反发热者，不死。脉不至者，灸少阴七壮。（306）

【解析】本条论述少阴病阳气来复之证及其预后。

少阴病阳虚阴盛，则必见吐利而澄澈清冷。阴寒内盛，阳虚不达四末，本当手足逆冷。今手足非但不逆冷，反而发热，则是阳气来复，阴寒退却的佳象，故为“不死”。

本条之“反发热”，亦可看做是身发热而不是手足发热。少阴病阳衰阴盛，本应恶寒身冷而蜷卧，若见发热者，则有两个可能：一为阴寒内盛，格阳于外的表现；一为阳气来复的征象。而鉴别的关键在于手足厥冷或是手足温。如果发热而手足厥冷不回，则属阴盛格阳，虚阳外越的危候；如果发热而手足温，则是阳气来复的好现象。今少阴病寒邪吐利，反见发热，而手足不逆冷，反映了阳气恢复、邪气退却，故曰“不死”。

脉搏是人体生命活动的一种反映，亦可反映病情的轻重浅深。少阴

病，本为阳气不足，其脉应见微弱，今吐利后而脉不至，要安心定志作具体分析。此时如果出现肢厥、恶寒、身蜷等一派阴寒之证，则为元阳大虚、真气不续，阴阳之气将要离决的危候；若手足不逆冷，而反发热的，这种脉不至的原因，则属吐利后正气暴虚，脉搏一时不能接续所致。当急温其阳以复其脉，可先“灸少阴七壮”而急回其阳。虽未言具体穴位，但治疗原则与大法已经确定，有的注家认为，应取少阴经的太溪穴，可供参考。

少阴病属疾病发展的严重阶段，因此需要医者密切注视病情变化，及时采取积极治疗措施，才能挽垂死之生命。不能因一时脉不至而放弃治疗。张仲景提出“脉不至者，灸少阴七壮”，亦属急救法之一。若灸后经过24小时，脉渐复者，则可救；脉仍不至者，则为真气亡绝，预后险恶。

少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。

（307）

【解析】本条论述少阴病由阴转阳移热于膀胱的证候。

少阴病，持续八九日，病情可能发生变化。或变为阳愈衰而阴愈盛，以致发展为亡阳之危境；或变为阳气来复，阴寒渐退而趋愈；也有随着阳热之来复，病由阴而转阳、证由寒而转热的。如本条所述，少阴病持续八九日，而见“一身手足尽热”，则是少阴之邪转出太阳之证。太阳与少阴为表里，阳复邪退，其病可由阴出阳，由里达外，由少阴之脏转出太阳之腑，因为由阴转阳，所以“一身手足尽热”。若太阳之热不解，燔灼阴络，迫血妄行，还可发生便血之证。

张仲景在此提出“一身手足尽热”，是针对阴盛格阳的身热而言，具有辨证意义。少阴病阴盛格阳证，也会见到身热，但其手足逆冷而不热。若为阳气来复，少阴转出太阳，则是“一身手足尽热”，两证截然不同，对比可以区分。

关于“便血”，张仲景并未明确指出由小便出，还是由大便出，后世医家也众说纷纭。方有执、喻嘉言认为热在膀胱，当是小便尿血；也有人认为，热可以在膀胱，但便血并不一定由小便出。因为太阳经包括足经膀胱与手经小肠，故上述两种意见均不为错。柯韵伯提出用猪苓汤治疗本证，亦可供我们参考。

以上两条，均论少阴病由阴转阳而出现发热之证。一是“反发热者，不死”，而手足不厥冷；一是“一身手足尽热”，是移热于膀胱，虽病变形式不同，但均属阳热来复的好现象。

少阴病，但厥无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻，或从目出，是名下厥上竭，为难治。（308）

【解析】本条论述少阴病下厥上竭的难治之证。

少阴阳衰，不能温煦四肢，则手足厥冷，然犹未至亡阳地步，故但见厥冷而无汗出。医不知无汗为阳虚而强发其人之汗，汗出则不但更伤其阳，又复内竭其阴。阳气大伤不能统摄阴血，阴血妄行而随虚阳上涌，或从口鼻、或从目出而成大衄，是为“上竭”；阳亡于下，则厥逆不回，气化已绝，则小便点滴皆无，是谓“下厥”。“下厥上竭”，即阴阳竭绝于上下而欲成离决之势，故“为难治”之证。

在临床上，下厥上竭证并非仅见于强发少阴之汗，而每见于内科杂病。曾在某院会诊一例尿毒症晚期患者，证见无尿，且伴有鼻衄，四肢厥逆，以及周身浮肿等证，脉沉而无力，舌胖苔白，据情断为“下厥上竭”之证，虽曾试图以真武汤加牛膝温阳利水，兼以引血下行之法治疗，但药后毫无效果，不数日而死亡。

以上两条虽都有出血，但病机不同，预后亦不同。第307条一身手足尽热而便血，是阴病转阳，阳热有余，迫血妄行，预后多良好；第308条见四肢厥逆而上窍出血，为下厥上竭，阳绝阴竭，预后极差，实属难治。

少阴病，恶寒身蜷而利，手足逆冷者，不治。（309）

【解析】本条论述少阴病纯阴无阳的危重证候。

本条与第302条都见恶寒身蜷而下利，属少阴虚寒重证。但一为可治，一为不治，辨证关键在于手足温与不温。手足温者可治，手足逆冷者不治。

“恶寒身蜷而利”，为阳虚阴盛，若手足温者，说明阳气尚存而有来复之机，虽然下利，亦能自止，故为可治之证。今恶寒下利，而手足逆冷不回，表明阴寒独盛，阳气不能为继，乃有阴无阳的危候，故曰“不治”。这里的“不治”，只能反映其病情的危重，在一定的医疗技术条件下，还是可以救治的，故不能见死不救，使人坐以待毙。

少阴病，吐利，躁烦，四逆者死。（310）

【解析】本条论述少阴病阴盛阳绝的死证。

少阴病吐利，为阴寒内盛。“躁烦”与烦躁不同。烦躁是以烦为主，因烦而躁，表现为意识清醒状态下的精神不安，常见于热证，如白虎汤证、承气汤证都见有烦躁，是阳热有余的证象；躁烦是以躁为主，表现

为无意识的肢体躁扰不宁，其证属阴，常见于阴盛阳气欲脱的危重证。

人体之阴与阳，既相互对立，又相互依存，任何一方都不能脱离另一方而单独存在。少阴病，阴寒盛极，阳不敌阴而欲亡脱，则其人躁扰不宁。阴寒盛极而阳气极虚，以致阴阳气不相顺接，则见“四逆”。四逆，指手冷过肘，足冷过膝，较一般手足厥冷更为严重。少阴病吐利本为阴寒内盛，又见躁烦、四逆，反映阴盛于内，阳亡于外，阴阳已见离决之势，其病极为重笃，故曰“死”。

据临床所见，如病人先有手足厥冷，而后出现烦躁，反映阳气来复，能与阴寒相争，是向愈的好现象；如果病人先见躁烦，随之出现四逆，而且四肢逆冷愈来愈重，多为阳气亡绝之死证。总之，察病机，断预后，都要看阴阳的盛衰变化。对少阴病来讲，尤应注意阳气的存亡，有阳者生，亡阳者死，这是一条基本规律。

少阴病，下利止而头眩，时时自冒者死。（311）

【解析】本条论述少阴病阳气上脱，阴阳离决的死证。

少阴虚寒下利，若下利自止，当属于阳气恢复、寒邪退却、疾病向愈的好现象。而今下利虽止，但又出现“头眩，时时自冒”之证。“头眩”，即头目晕眩。“时时自冒”，冒当冒明讲，指昏厥失神的病证。此证见于利止之后，则多是阴液下竭，阳气上脱，阴阳离决的反映。所以说这种“下利止”，也就不是阳气恢复的佳兆，而是阴竭下断，无物可利的恶候，故虽利止亦不主生，而反为死证。

少阴病，四逆恶寒而身蜷，脉不至，不烦而躁者，死。（312）

【解析】本条论述少阴病阴盛于内、阳扰于外、阴阳离决的死证。

少阴病，见四肢厥逆，恶寒身蜷，是阴寒极盛，阳气极衰的恶候。“脉不至，不烦而躁”，一方面反映了阳气极虚，阴寒独盛，无力鼓动血脉，虚阳躁扰于外，同时也可见于阳损及阴，阴液涸竭，脉道不续，阴不敛阳以致阳气欲脱的病证。无论是阳虚至甚，或是阴阳俱虚竭，见脉不至、躁扰不宁，均为阳气欲脱、阴阳离决的险证，故亦主死。

本条的“脉不至”与第306条的脉不至全然不同。第306条虽亦见脉不至，但手足不逆冷，反发热；本条脉不至，则伴见四逆，恶寒身蜷，不烦而躁等证。一为有阳，一为无阳。所以预后有生死之别。

少阴病，六七日，息高者，死。（313）

【解析】本条论述少阴病元气离根的死证。

“息高”，是指呼吸浅表，气息浮游于上，不能纳气归根的证候。肺主呼气，为气之标；肾主纳气，为气之本。“呼出心与肺，吸入肝与肾”。呼吸浅表急促带喘是肾不纳气归根的表现。

先天之精藏于肾，肾为元气之根。少阴病已经六七日不愈，则元气大伤。气不归根而见“息高”，是气欲脱于上的危证，故主死。气不归根，为无根之气，故息高又称“游息”。程郊倩所谓：“游息仅呼于上而无所吸也”，即指息高而言。

少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，复烦躁，不得卧寐者，死。（314）

【解析】本条论述阴盛阳脱，正不胜邪的少阴死证。

“脉微细沉”是少阴病本脉，“但欲卧”是少阴病本证。汗出不烦，是阳气外亡的表现。因为在一般情况下，汗出多伴有烦。有烦即有热，有热则汗出。此之汗出却不烦，并在脉微细，但欲寐脉证上出现，说明汗出并非因于阳热，而是阳气外亡的表现。阳虚阴盛，阴寒上逆，故“自欲吐”。阳虚的脉与证已见，本当急温少阴以扶阳消阴为务，但由于治不及时，拖至五六日之后，使阳气越来越虚，阴寒邪气越来越盛，以致出现了自利，烦躁，不得卧寐的证候，说明病情在逐渐恶化。阴盛而阳脱于下则利；阳极虚而不能入于阴，则见烦躁不得卧寐；阴盛阳脱，正不胜邪，阴阳离决，故主死。

以上从第295条至314条的内容，可看做是少阴病的总论部分，其内容包括少阴病的脉证、病机、治疗禁忌及预后转归等。第315条之后，将介绍少阴病的各论，其中包括寒化证、热化证以及表里证治等等。

少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。（315）

麻黄附子细辛汤方：

麻黄二两，去节 细辛二两 附子一枚，炮，去皮，破八片

上三味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【解析】本条论述太阳少阴两感的麻黄附子细辛汤证。

少阴病，本为阳虚之证，应以无热恶寒为主。今反见发热，而脉反

沉，则发热为太阳受邪，脉沉则为少阴阳虚，这种表里同病，则叫做“两感”为病。治太阳应发汗，治少阴应温阳，所以后世称麻黄附子细辛汤为温经发汗之法。此条应和第96条对比，以见“两感”的提法有从太阳和从少阴的不同。

麻黄附子细辛汤由麻黄、附子、细辛三药组成，方用麻黄发汗以解太阳之表；附子扶阳以温少阴之里；细辛则既能解在表之寒，尤能散少阴之邪，与麻黄、附子相伍，可兼有表里两治之功。三药合用，温少阴之经而发太阳之表，具有扶正祛邪、温阳解表的作用。但麻黄、细辛毕竟辛散有力，走而不守，易伤正气，故本方只适用于少阴始病之时，而以正虚不甚者为宜。

少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤微发汗。以二三日无里证，故发微汗也。（316）

麻黄附子甘草汤方：

麻黄二两，去节 甘草二两，炙 附子一枚，炮，去皮

上三味，以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【解析】本条承上条论述太阳、少阴两感的麻黄附子甘草汤证。

少阴病，即上述表里同病，得之二三日，表证仍不解，但又未见厥逆、下利等里证。然病二三日，则与始得之的病情不同，此时正气较虚，故不能再加重剂的麻黄附子细辛汤，而改用麻黄附子甘草汤，微发其汗则愈。“以二三日无里证”，是作者自注句，指出虽病有二三日，然无下利腹痛之里证，故仍可微发汗，意在言外，若有里证时，则此方便不能用矣。

麻黄附子甘草汤即麻黄附子细辛汤去细辛易甘草。因本证邪轻势缓，故去细辛以防辛散太过，加甘草可益气和中，保护正气。麻黄、附子、甘草三药配伍，既能发微汗，而又不伤少阴之正气。

总结太阳、少阴两感证治，可以看出其治疗亦有开手三法：风寒之邪初客少阴，脉沉，反发热，用麻黄附子细辛汤温经发汗，这是第一阶段；邪客少阴，病程稍长，正气较弱，但又未出现下利清谷、四肢逆冷之阴寒里证，则用麻黄附子甘草汤微发汗，此为第二阶段；如果服用麻黄附子细辛汤和麻黄附子甘草汤后，病不解，仍见周身疼痛，脉沉，甚

或下利清谷、四肢厥冷等里虚寒重证，则属第三阶段，当用四逆汤以温阳祛寒，急救其里，不可再用麻黄之属攻表。

少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。
(317)

黄连阿胶汤方：

黄连四两 黄芩一两 芍药二两 鸡子黄二枚 阿胶三两

上五味，以水五升，先煮三物，取二升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

【解析】本条论述少阴阴虚火旺的证治。

手少阴心为火脏，足少阴肾为水脏。邪犯少阴而少阴为病，往往可因个体体质因素不同，而发生寒化与热化两种不同的证候。如素体阳虚阴盛，则外邪从阴化寒而形成少阴寒化证；如素体阴虚阳亢，则外邪从阳化热而形成少阴热化证。

正常生理情况下，心火下交于肾，以温肾阳，而使肾水不寒；肾水上济于心，以滋心阴，而使心阳不亢。心肾水火交通既济，则阴平阳秘精神乃治。若素体阴虚阳盛，侵入少阴之邪又经过“二三日以上”，则可以从阳化热而出现少阴阴虚火旺之证。少阴阴虚，肾水不能上济于心，心火无水制而上亢，则见“心中烦，不得卧”，言烦之甚而不能安也。此证每晚当阳入于阴之时则烦甚而不能卧寐；反过来说，越是不能入寐则越心烦。此即阴虚火旺、心肾不交最典型的证候。治以黄连阿胶汤滋阴泻火，使心肾相交、水火既济则愈。

黄连阿胶汤用黄连、黄芩泻心火以除烦，用阿胶滋肾水，鸡子黄养心血以滋少阴之阴。芍药与芩、连相配，酸苦涌泄以泻火，与鸡子黄、阿胶相配，酸甘化液以滋阴，又能敛热安神以和阴阳。

煎药方法，有两点应注意：一是阿胶烊化于汤液中或烊化另兑；二是鸡子黄不可与药同煎，应在汤液煎好去滓后纳入，即如方后注所说：“小冷，内鸡子黄，搅令相得”。

本方在临床用于阴虚火旺之心烦失眠疗效颇佳。曾治一中学教员，患失眠证，每至夜晚，则精神兴奋，容易激动，心烦不宁，难以入寐。舌红、苔薄黄，脉细数，一派阴亏火旺之证。遂用黄连阿胶汤原方，药后不久即入睡。

少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。（318）

附子汤方：

附子二枚，破八片，去皮 茯苓三两 人参二两 白术四两 芍药三两
上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【解析】本条论述少阴寒化证的附子汤证。

“少阴病，得之一二日”，言其病程短。证见“口中和”，即口不干、不渴、不苦、不燥，说明里无热象；“背恶寒”，是少阴阳虚不护所致。督脉及太阳经多循行于背部，故背为阳之府，少阴阳虚，则以背恶寒为突出。证属阳虚而生外寒，治法须灸、药并用，即文中所谓“当灸之，附子汤主之”。

此为一证二方之法，对二法的具体运用，有两种意见：一是灸药并用，不分先后，可以借灸法壮元阳、消阴寒，以加强药物温经散寒的作用；二是先灸后药，示人阳虚证救治宜急，先灸取其方便而易速取，以争取治疗时间，然后再服附子汤，以持续发挥作用。至于灸何穴位，根据临床实践，以选用大椎、膈俞、关元等穴为好。

“背恶寒”，在第177条中的白虎加人参汤证中亦有此证，然其病机属阳明热盛，津气两伤，而伴有身热，大汗，口燥渴等证，且背恶寒的程度也较附子汤证为轻。本条所论为少阴阳虚之背恶寒，并无烦渴等热证，而“口中和”之证，即是有寒无热的辨证眼目，况且其恶寒的程度也较白虎加人参汤为重，二者寒热迥别，不难鉴别。

附子汤用附子温肾以扶真阳之本；用人参大补元气以补后天之虚。凡阳虚则阴必盛，阴盛则水湿凝滞而不化，故加茯苓、白术健脾利水化湿，且有利于阳气之宣通。然此四药多温燥，实有伤阴之虑，故用芍药以制术附之温燥而护阴，且配苓术又可助疏泄以利水，同时又有缓急止痛之功。本方以附子、人参为主药，故其主治在于补阳益气而固根本；附子用熟不用生，且剂量较大，说明重在扶阳而不在散寒；附子与苓术同用，不仅能扶阳，而且能行水祛湿以消阴，故对治疗阳虚寒湿凝滞的身痛、骨节疼痛有效，这在下一条将得到证明。

少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。

（319）

【解析】本条再论阳虚有寒的附子汤证。

“身体痛”，“骨节痛”，酷似太阳表实的麻黄汤证。但身不热而“手足寒”，脉不浮而见沉，说明阳虚而有寒，故属于少阴病的寒化证。少阴阳虚，不能温煦四末，故“手足寒”，即手足发凉；阳虚阴盛，鼓动无力，则脉沉；阳虚寒湿不化，流注关节，故身体痛，骨节痛，为寒主痛。

身痛一证，《伤寒论》有多处论及，如太阳病的麻黄汤证、桂枝汤证、新加汤证以及本篇的附子汤证。麻黄汤与桂枝汤证，为风寒之邪闭塞肌表，用麻、桂发汗解表后，身痛自除；新加汤证为汗后身疼，脉见沉迟，属气血营卫虚损，体表失养，故用新加汤补益气血、疏通营卫，则身痛可止；本证属阳虚有寒，寒湿凝滞，故用附子汤扶阳抑阴，温化寒湿，则身痛可痊。

以上两条，皆论附子汤证，第318条以背恶寒为主证，是从阳气虚的角度提出的；第319条以身痛、骨节痛为主证，则是从阴寒盛的角度提出的。两条合参，方能全面掌握本方的临床运用。

少阴病，下利便脓血者，桃花汤主之。（320）

桃花汤方：

赤石脂一斤，一半全用，一半筛末 干姜一两 粳米一斤

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温服七合，内赤石脂末，方寸匕，日三服。若一服愈，余勿服。

【解析】本条论述下焦虚寒不约便脓血的证治。

少阴病，本为下焦虚寒之证。肾阳虚衰，火不暖土则下利。下利日久，肾气愈伤，关门不固，则滑脱不禁。虚寒久利，由阳及阴，气血不摄，而致下利脓血。治用桃花汤温阳散寒，涩肠固脱。

桃花汤由赤石脂、粳米、干姜三药组成。赤石脂性温而涩，入下焦血分，收涩固脱；干姜守而不走，温中焦气分而散寒；粳米益气调中，补久利之虚。赤石脂一半煎汤，一半用末冲服，取其收涩气血，固肠止利。临床对纯虚无邪，下利滑脱不禁之证常可取效。

少阴病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止便脓血者，桃花汤主之。（321）

【解析】本条承上条，再论下焦虚寒便脓血证治。

少阴病二三日至四五日，则病程较长，虚寒更甚。阳虚阴盛，寒凝不解则腹痛，阳虚失于温化，则下利不止，利多伤液而小便不利；阳虚气陷，不能摄血，则大便脓血。仍治以桃花汤温阳散寒、涩肠固脱。

综合以上两条，可知桃花汤证当具有以下几个特点：一是下利不止，滑脱不禁，大便稀薄，脓血杂下，血色晦暗不泽，其气腥冷不臭，无里急后重和肛门灼热感；二是伴见腹痛，但喜温喜按；三是下利不止，必然伤津液，故小便少而不利。

少阴病，下痢便脓血者，可刺。（322）

【解析】本条论述少阴病阴虚有热便脓血的可刺之法。

古代针、灸之法，一般说来刺法是泻其实热；灸法是祛其虚寒。今少阴病，下利便脓血，治以刺法而不用灸法，则知其为热利而非寒利。少阴病，阴虚阳亢，邪气从阳化热，热灼阴络而便脓血，其证当有里急后重，下利肛热，舌红少苔等阴虚有热之象，此时再用桃花汤温阳固脱，实非所宜。故用针刺之法，随其实而泄之。注家云可刺幽门、交信等穴，也有人主张用白头翁汤治疗，均可进行参考。

本条与上两条，同为少阴下利，大便脓血之证。然病性一寒一热，治法一补一泻，两相对比，则辨证的意义自在其中。

少阴病，吐利，手足厥冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。（323）

【解析】本条论述少阴病，吐利烦躁的可治之证。

第310条“少阴病，吐利，躁烦，四逆者死”，看来与本条证候大致相似。但第310条被认为是死证，而本条却为可治，原因何在？

第310条言少阴病，吐利交作，以致阳气大衰，阴寒内盛。若再见躁烦、四逆，则为独阴无阳，残阳欲脱，其“躁烦”，必是躁大于烦，以肢体的躁扰不宁为主；其“四逆”，必是四肢厥逆不回。证情危笃，故为死证。本条论少阴阳虚寒盛，寒邪伤及脾胃，脾胃受伤，升降失职，则吐利并作。阳气被寒邪所郁遏，不能温养四末，故手足厥冷。此“手足厥冷”与前之“四逆”则有程度的不同。“四逆”为四肢厥逆，其厥冷上以过肘，下以过膝，比厥冷仅在手足者要严重得多。本条“烦躁欲死”是形容病人烦躁得很厉害，以致达到辗转反侧，痛苦不堪，不能耐受的程度。这说明人体的阳气虽被寒邪所抑，但尚能与阴邪抗争，阳与阴争，因而烦躁欲死。况且本证之烦躁又出现于手足厥冷之后，更说明阳气在身而有可治之机。故用温中散寒、降逆止呕的吴茱萸汤治疗，则其病可愈。

结合阳明病“食谷欲呕者，属阳明也，吴茱萸汤主之”及厥阴病的“干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之”的内容来看，本条虽是吐利交作，但应以呕吐为主，与太阴病的吐利交见而以下利为主之义而各有侧重。

少阴病，下痢，咽痛，胸满心烦者，猪肤汤主之。（324）

猪肤汤方：

猪肤一斤

上一味，以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白粉五合，熬香，和相得，温分六服。

【解析】本条论述少阴阴虚咽痛证治。

手少阴经上挟咽，足少阴经循喉咙挟舌本。故少阴经脉受邪，或少阴脏病及经，均可见到咽喉部病变。

少阴病虚寒下利，虽然寒邪可以随利而减，但津液也必因利而被耗损。阴液损伤，导致虚火循经脉上熏于咽喉，故而咽痛。少阴之脉，其支者，从肺出络心，注胸中。故少阴虚火循经上扰，经气不利，还可出现胸满、心烦等证。本证乃属寒随利减，热随利生，少阴水火不济，虚火上炎之证，故用猪肤汤润肺肾、益肠胃而治虚热。

猪肤即猪皮，可滋肺肾，清少阴浮游之火，此物虽润，但无滑肠之弊。但在入药时一定要将猪皮上的肥肉刮净。白蜜甘寒生津润燥以除烦。白粉，即炒香之白米粉，能醒脾和胃，以补下利之虚。本方清热而不伤阴，润燥而不滞腻，对治疗阴虚而热不甚，又兼下利脾虚的虚热咽喉疼痛，最为相宜。

曾治一女学生，22岁。因唱歌而致咽喉疼痛，声音嘶哑。屡服麦冬、胖大海之类药物无效。适值即将演出之际，心情甚为焦虑。患者舌红少苔、脉细。遂断为肺肾阴虚，虚火上扰“金破不鸣”之证。拟猪肤一味熬汤，调鸡子白，徐徐呷服，尽一剂则咽痛止而音哑除。

少阴病，二三日咽痛者，可与甘草汤；不差者，与桔梗汤。（325）

甘草汤方：

甘草二两

上一味，以水三升，煮取一升半，去滓，温服七合，日二服。

桔梗汤方：

桔梗一两 甘草二两

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

【解析】本条论述少阴虚火上扰所致咽痛的治法。

少阴病二三日咽痛者，乃少阴阴火上扰，客于经脉所致，若咽部尚未溃破生疮者，则治以甘草汤。服甘草汤后，病仍不瘥，即咽喉疼痛不解者，与桔梗汤则愈。

据临床观察，凡少阴虚火上扰之咽痛，多为咽部充血不甚，并兼见舌红少苔、脉细数、小便黄赤而量少等阴虚有热的证候，与一般火热实证的咽喉疼痛迥然不同。

甘草汤只用生甘草一味。统观《伤寒论》，用甘草处甚多，但生用者只此一处，其他均以炙甘草入药。生甘草味甘平，善治少阴阴中之伏火，并能清热解毒，缓急止痛。后世有医家用一味生甘草四两，浓煎内服，治疗会阴部脓肿（名“海底发”），即取其清解阴经毒热的功效。桔梗辛开苦泄，而有宣肺、开结、排脓、解毒的功效。

少阴病，咽中伤生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。

（326）

苦酒汤方：

半夏洗，破，如枣核大十四枚 鸡子一枚，去黄，内上苦酒著鸡子壳中

上二味，内半夏，著苦酒中，以鸡子壳，置刀环中，安火上，令三沸，去滓，少少含咽之。不差，更作三剂。

【解析】本条论述少阴病咽中伤生疮的治法。

邪热灼伤少阴之络，致使咽部溃烂而生疮疡；痰热浊邪包括脓性分泌物塞于咽喉，使声门不利，则“不能语言”，声音难出。治用苦酒汤，少少含咽，以涤痰消肿，敛疮止痛。

苦酒即米醋，味苦酸。能制火毒，消疮肿，敛疮面，又能活血行瘀

止痛。鸡子白甘寒，利血脉，止疼痛，润咽喉以出声音。半夏涤痰散结，清洁疮面，以开喉痹。为使药效持续作用于咽喉，故应“少少含咽”。这种服法及剂型，实为今之口含剂的先河。

少阴病咽中痛，半夏散及汤主之。（327）

半夏散及汤方：

半夏洗 桂枝去皮 甘草炙。以上各等分

已上三味，各别捣筛已，合治之，白饮和，服方寸匕，日三服。若不能散服者，以水一升，煎七沸，内散两方寸匕，更煎三沸，下火令小冷，少少咽之。

【解析】本条论述寒客少阴咽痛的治法。

本条述证简单，只有“咽中痛”一证。以方测证，可知此“咽中痛”当属寒客痰阻，少阴经脉不利，其证属喉痹范畴。因是寒邪所伤，必以咽喉疼痛较甚，并兼见痰涎缠喉，咳吐不利等证。其治当以半夏散及汤方涤痰开痹，温经散寒以止痛。

《内经》云：“寒淫所胜，平以辛热，佐以甘苦”。半夏散及汤用半夏、桂枝之辛，以散寒涤痰；甘草之甘以和中缓急止痛。白饮和服，取其保胃存津，以防半夏、桂枝辛燥劫阴。不能服散者，可作汤剂，故合称半夏散及汤。

以上从第324条至327条，皆论少阴咽痛证治。由于少阴经脉挟咽喉或循喉咙，故多病有咽痛的特点，咽痛也可视为少阴病的经证。

少阴病，下利，白通汤主之。（328）

白通汤方：

葱白四茎 干姜一两 附子一枚，生用，去皮，破八片

上三味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

【解析】本条论述少阴寒证，阳虚且抑的证治。

少阴病虚寒性下利，当首选四逆汤温经回阳而止利。而本条少阴病

下利为何先选用白通汤？可能有两方面的理由：其一，用过四逆汤而不效，为病重药轻，故改用白通汤治疗；其二，少阴虚寒性下利，阳气衰微，阴寒内盛，寒来困阳，致使阳气抑郁而不达。阳虚且抑之证，则非四逆汤所能奏效，故改用白通汤破阴以通阳。

白通汤即四逆汤去甘草之缓敛，加葱白之辛通，故能破阴寒之结，以舒展抑郁之阳气。

少阴病，下利脉微者，与白通汤；利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之。服汤脉暴出者死，微续者生。（329）

白通加猪胆汁方：

葱白四茎 干姜一两 附子一枚，生，去皮，破八片 人尿五合 猪胆汁一合

已上三味，以水三升，煮取一升，去滓，内胆汁、人尿，和令相得，分温再服，若无胆亦可用。

【解析】本条承上条，再论少阴寒盛、阳虚且抑的证治及预后。

“少阴病，下利脉微者，与白通汤”，与上条意同。此言“脉微”，即突出了白通汤证阳虚寒盛，阳被阴抑的病机特点。与白通汤破阴通阳，阳气振奋，利当自止。若服白通汤，非但不效，且病情更加严重，出现“利不上，厥逆无脉，干呕烦”等证，这是因为阴寒内盛则下利不止，阳气虚衰则厥逆无脉。至于干呕心烦，则是阳气被阴寒之气所格拒而出现的虚阳上浮，“阴盛格阳”的假热之象。

王冰说：“凡大寒大热者，必与违其性者争雄，异其气者相格也。”因为阴寒太盛，往往对大热之药拒而不受，以致更加激发了寒邪的势力，因此服汤后证情反而加重。在治疗上，必依《素问·至真要大论》“逆而从之，从而逆之”，“逆者正治，从者反治”的道理，而变正治为从治之法。在白通汤内加入猪胆汁之苦寒、人尿之咸寒，以苦咸寒之药性来顺从疾病的阴寒之性，从其性而治之，使其不相格拒。这是大多数注家依《内经》思想的传统解释方法，也是医疗实践中宝贵经验的总结。但是，从病情发展及处方用药看，上述的解释还不够全面。因为病至少阴不仅伤阳，同时“下利不止”也必然使阴液受到损伤，“无脉”即是阴分已虚的有力见证。故“利不止，厥逆无脉，干呕烦”乃属阴阳俱虚之证。如果单用白通汤治疗，则助阳有余，而益阴不足。阴阳互根，若无阴则阳无以存，机能的恢复就缺少了物质基础。况且姜附阳热之品会进

一步伤阴。所以药后不但不效，反而会使证情加重，以致出现利不止、厥逆无脉、干呕烦等证候。人尿和猪胆汁均所谓“血肉有情之品”，易被吸收而直接为人所用，是草木滋阴之品所不能比拟的。人尿（一般用童便）咸寒益阴，猪胆汁苦寒滋液兼清虚热，两药同用能续已竭之阴、滋将涸之液。所以白通汤加人尿、猪胆汁，一方面是借其性寒反佐，引阳药直入阴分，使阴阳不发生格拒；更重要的是用其补津血，增体液，补充人体阴分的不足，以奠定阳气来复的物质基础，达到“阴平阳秘”、“阴阳自和”的治疗目的。

由于病情已发展到阴液下脱而不继，虚阳上扰而被格拒的阶段，故服了白通加猪胆汁汤后，也不能说一定获愈，当结合脉证作进一步的观察。若服药后脉暴而出见浮大者，则为元气欲脱而难以为继的危象，预后多属不良，故曰“服汤脉暴出者死”；若服药后，脉由沉伏不出徐徐而渐至，是寒邪渐退，真阳已回，正气逐渐恢复，疾病向愈的佳兆，此即所谓脉“微续者生”。

白通加猪胆汁汤的方药组成及配伍意义，上文已做了分析，不再赘述。下面仅就此方有争议的几个问题，谈几点意见：

第一，“白通汤”方名的由来及方药组成的问题：有人认为“葱白”色白，善能通阳破阴，故名“白通”。也有人认为白通乃指人尿，因为古时称大小便为“通”。白通汤中有人尿，故取名白通。持此意见者还指出，白通加猪胆汁汤只提加猪胆汁，言外之意即白通汤的组成中已有人尿的成分。这两种意见，似乎后者的观点更有道理。

第二，关于方中猪胆汁的取舍问题：张仲景说：“无胆亦可用”，似乎胆汁为可用可不用的药物。据程老先生（注：指程门雪）的治疗经验证明，方中的猪胆汁绝非可有可无之事。程老曾用白通加猪胆汁汤救治两例因食“河蟹”中毒的患者，其一按方使用了猪胆汁，另一因未找到猪胆汁。治疗的结果是，加猪胆汁者获痊愈，而未用者竟抢救无效。此足以说明对方中猪胆汁一药的治疗作用，是绝不可忽视的。

第三，关于加人尿、猪胆汁是否科学的问题：前面说过，人尿、猪胆汁乃生物体内的产物，容易吸收而直接为人所用，非草木之品所能比。且二药既不损阴，也不碍阳，实乃平和有效之药。现猪胆汁仍是一些药物的重要原料，而人尿，特别是童便，一直为历代医家所习用。

《医宗金鉴》的“柴胡清骨饮”方中就有人尿和猪胆汁，此方对长期不愈的“低热”每能获得满意的疗效。另外，妇女产后或其他外伤所致之“失血性休克”，在输血条件不具备的情况下，急以人尿服之，即可收到某种抢救的效果。再如跌仆损伤后，由于体液的消耗，病人每感口渴，特

别是在野外条件不备的情况下，切不可投以冷水，若以人尿代饮，则是有百利而无一害。对人尿治疗作用的研究，又开始引起医学家们的注意。我们应当用唯物主义的辩证观点加以对待，只有在实践中不断地检验，并运用科学方法进一步整理研究，才能确定它的实用价值和科学地位。

少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。（330）

真武汤方：

茯苓三两 芍药三两 生姜三两，切 白术二两 附子一枚，炮，去皮，破八片

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

后加減法：

若咳者，加五味半斤，细辛、干姜各一两。若小便利者，去茯苓。若下利者，去芍药，加干姜二两。若呕者，去附子，加生姜，足前成半斤。

【解析】本条论述少阴病阳虚水泛证治。

“太阳病篇”第86条所列的真武汤证，是太阳病过汗损伤少阴之阳而致水泛为患；本条则是论述少阴阳虚阴盛的水邪为患。两条互相参照、对比发挥，以见太阳与少阴一为水腑，一为水脏的表里关系，以及其病理上的相互影响。

少阴病，得之二三日不愈，至四五日邪气入里则见腹痛、下利、小便不利等证。这是因为少阴阳虚不能制水，以致水邪泛滥而为病。水寒在内，筋脉拘挛，则腹痛；水寒内蓄，阳虚不化，则小便不利；水寒外溢，阴凝重着，则四肢沉重疼痛；若水寒下渍于肠，则下利腹泻。

本证的“四肢沉重疼痛”，与附子汤证的“手足寒，骨节痛”在病机与证候表现上不尽相同：彼为少阴阳虚有寒，寒邪收引，营卫凝涩不通而出现的骨节疼痛；此为阳虚不能制水，水邪溢于四肢为患，故痛而且重，而肢重却是主要的证候特点。

由于水邪变动不居，可随气机升降而到处为患，故其或然之证甚多：若水邪上凌心肺，可见心悸而咳；上逆于胃，则气逆而呕；泛于肌肤则肿；上蒙清窍，则头目眩晕；下迫大肠，则下利更甚。若阳虚肾关不固，不能制水，亦可见小便利。上述诸证，若究其病源，皆属肾阳虚，不能制水，水邪泛滥为患。因水邪为致病的重点，故曰“此为有水气”。治以真武汤温阳祛寒，化气行水。

真武汤用附子之辛热，温经回阳以散寒水；辅以白术温运脾气，补土以制水；术、附合用，还可温煦经脉以除寒湿；茯苓淡渗，协白术以利水；生姜辛温，配附子扶阳消阴以散水邪；芍药活血脉、利小便，且能制约姜、附之辛燥，使之温经散寒而不伤阴。方中诸药相辅相成，相互为用，可谓有制之师。

本方与附子汤，均为温阳之剂，方剂的组成也仅有一药之差，但两方的作用是不相同的。柯韵伯指出：附子汤为大温大补之方，与真武汤似同而实异，倍术附去姜加参，是温补以壮元阳，真武汤还是温散而利肾水也。道出了两方的基本不同之处。

少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面赤色，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止，脉不出者，通脉四逆汤主之。（331）

通脉四逆汤方：

甘草二两，炙 附子大者一枚，生用，去皮，破八片 干姜三两，强人可四两

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。其脉即出者愈。

面色赤者，加葱九茎。腹中痛者，去葱，加芍药二两。呕者，加生姜二两。咽痛者，去芍药，加桔梗一两。利止脉不出者，去桔梗，加人参二两。

【解析】本条论述少阴病里寒外热，阴盛格阳的证治。

少阴病下利，完谷不化，说明阳气极虚而阴寒极盛，肠胃机能极度衰弱，已丧失了腐熟水谷的能力。由于阴寒太盛，将弱阳格拒于外，因此出现“身反不恶寒，其人面赤色”等与疾病本质相违的格、戴证候。此证为“里寒外热”，指内有真寒，外有假热，是阴阳格拒的表现。阴盛格阳，阴阳气不相顺接，故手足厥逆；阳气虚甚，鼓动无力，则脉微而欲

绝。

这种真寒假热的证候，也可出现众多的兼见证：如寒凝气滞可见腹痛；阴寒气逆，胃失和降，可见干呕；少阴虚阳循经上浮，可见咽痛；阳衰阴竭，化源已绝，可见利止而脉不出。其证远较四逆汤证为重，若不及时救治，恐有大汗亡阳之变。治疗当以通脉四逆汤消阴、潜阳，通脉救逆为法。

通脉四逆汤即四逆汤重用附子、倍用干姜，从而使其回阳抑阴之力更强。若在通脉四逆汤证的基础上更见面色赤的，是为阴盛于下格阳于上的“戴阳”证，应于本方中加葱白，以破阴逐寒，招纳亡阳，使阳气得复而归于下焦；若因寒凝气滞，血脉不和而见腹中痛者，则减去辛滑走阳而不利于血的葱白，另加芍药以利血脉、缓急止痛；若胃气挟饮邪上逆而作呕者，则加生姜化饮止呕；若喉痹咽痛者，则去芍药之酸敛，加桔梗以开喉痹；若阴阳俱竭，气血大虚，利止脉不出者，则去桔梗以防耗气伤阴，加人参以益元气而复脉。

对本方药物组成，注家们有不同意见：一种意见认为本方应有葱白，因为既有面赤色，不用葱白则不足以破阴通阳，招纳阳气；另一种意见认为，方中应有人参，因为人参有复脉的作用，无人参则方与证不能相应。以上意见均可参考。

少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。（332）

四逆散方：

甘草炙 枳实破，水渍炙干 柴胡 芍药

上四味，各十分，捣筛，白饮和，服方寸匕，日三服。

咳者，加五味子、干姜各五分，并主下痢。悸者，加桂枝五分。小便不利者，加茯苓五分。腹中痛者，加附子一枚，炮令坼。泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，煮取三升，去滓，以散三方寸匕，内汤中，煮取一升半，分温再服。

【解析】本条论述阳气郁遏致厥的证治。

少阴司水火，内寓真阴真阳。水火交通，阴阳既济，是人体正常生命活动的必要条件。要维持水火、阴阳的交通既济，有赖于少阴的枢机作用，也就是说，少阴不仅为“三阴之枢”，而且也是调节阴阳、水火平

衡的重要枢纽。

少阴病见四肢厥逆，以阳虚阴盛者居多，但也有见于阳气郁遏而不达四肢的。少阴阳衰阴盛之四肢厥逆，当见恶寒、身蜷、下利、脉微等一派全身虚寒的证候，应用四逆汤一类方剂回阳救逆。本条之四肢厥逆，并不见虚寒等证候。然其致厥之由，《内经》云：“四肢者，诸阳之本也”。若少阴之枢不利，阳气被郁，不能疏达于四末，则亦可形成四肢逆冷之证。其治法可用四逆散疏畅阳郁、条达气血，使阳气得以舒展而布达于四肢，则厥逆亦必迎刃而解。

四逆散用柴胡、枳实解郁开结以疏达阳气，芍药配甘草和血以利阴，即“治其阳者，必调其阴，理其气者，必调其血”之义。若兼有肺寒气逆作咳者，可加干姜、五味子以散肺寒、敛肺气；兼心阳不振而作悸者，则加桂枝以温通心阳；水停于下而小便不利者，加茯苓淡渗以利水；寒凝于里而腹中作痛者，加附子温阳散寒以止痛；寒滞气阻而泄利下重者，加薤白以散寒通阳。

结合临床观察，四逆散证的原因不外两个方面：一是过服寒凉药物致使阳气冰伏，闭郁而不达于四肢。如外感热病过早或过量使用寒凉药后，出现手足厥逆即是。二是由于精神刺激，使肝气郁结不舒，少阴阳气被郁而不达于四末，以致出现四肢厥逆。凡此厥逆，使用四逆散条达气血、疏畅阳郁，则多能获得较好疗效。

曾治全某，男，32岁。患者手足汗出，厥冷而麻痛不堪。手足汗出随厥之深浅而有多少不同，厥深则汗出亦多，厥微则汗出亦少。曾服附子、干姜等回阳救逆之药无效。视其人身材高大，面颊丰腴，不像寒厥体征，然握其手却冷如冰铁。其脉弦而任按，舌红而苔白。此证既非阳虚之寒厥，又非阳盛之热厥，从其脉弦辨证，可知证属阳郁无疑。阳郁于里，不达四肢而为厥；郁阳迫阴外渗，则为汗出。阳郁愈甚，则手足厥冷愈深而手足汗出亦就愈多。反之，厥微者，则汗出亦少。为疏四逆散原方，以观其效。服药后，患者自觉有气往下行，至脐下，则微微跳动，周身顿觉轻爽，而手足转温，汗亦不出。患者甚喜，以为病将从此而愈。不料两剂服完，手足又厥，汗出依旧。二诊以上方加桂枝、牡蛎，意使桂枝配芍药以调和营卫，牡蛎伍芍药以敛汗固阴。服两剂，手足见温而汗出亦少，但续服则仍无效可言，病情反复无常，使人费解。重温王冰“益火之源以消阴翳，壮水之主以制阳光”的名句，受到启发而恍然有悟：此证每方皆效，但疗效不巩固，关键在于只知疏达阳郁，不知滋阴以敌阳也。阴不足，无以制阳，则反被阳逼而为汗，阳无偶则自郁而为厥。郁阳之气宜疏，而弱阴又岂可不救？于是本肝肾同治，理气与滋阴并行之法，为疏四逆散与六味地黄汤合方。服六剂，厥回手温而

汗亦止。后随访得知，其病终未复发。

少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦，不得眠者，猪苓汤主之。（333）

【解析】本条论述少阴阴虚有热，水热互结的证治。

少阴主水，对水液代谢起着重要作用，然少阴的主水功能，和肾阳及肾阴的平衡协调有关。若肾阳虚衰，不能制水，则可上泛而为患，治用真武汤扶阳祛寒以镇水。本条的水气泛滥则是因肾阴亏损，阴虚生热，热与水结，从而影响肾主水的功能，使水蓄不行而致病。

少阴阴虚水停，水热互结，应见小便不利；阴虚热扰，阳不入阴，故见心烦不得眠。水热互结，津液不能上承，故见口渴；阴虚水停，泛滥三焦，迫于肺则咳，逆于胃则呕，渗于大肠则下利。

本证与黄连阿胶汤证、栀子豉汤证虽然都有心烦不寐一证，但本证属少阴阴虚，水热互结证，故以咳而呕渴，小便不利，舌红苔水滑，脉细数而弦为辨；黄连阿胶汤属肾水不足不能上济于心，心火偏亢的阴虚火旺证，故以舌质红绛，苔净而光，口燥咽干，脉细数，小便色赤为辨；栀子汤证乃属郁热留扰胸膈，故以反复颠倒，心中懊恼，烦郁特甚而使人无可奈何，而为辨证要点。

少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。（334）

【解析】本条论述少阴病急下证之一。

阳明病有三条急下证，而“少阴病篇”也有三条急下证。它们之间可以说是一个问题的两个方面，有着内在的联系。阳明三急下证，是讲阳明腑实证的病势急、发展快、有劫灼少阴真阴的征象时，即应用大承气汤急下以存阴，而所存之阴，正是少阴之真阴。少阴三急下证，是讲少阴被燥热所灼，大有阴亡水竭之势，故欲存阴液，必须用釜底抽薪之法，以急下阳明燥热之邪。

本条言少阴病只二三日，便见口燥咽干等少阴阴液被劫的证候，说明阳明燥热内盛，病势危重，故当与大承气汤急下阳明之燥热，以保存少阴之阴液。否则若待土燥水竭，其后果将不堪设想。本证既言急下，必见可下之证，正如钱天来所说：“但口燥咽干，未必即是下证，亦必有胃实之证，实热之脉……方可急下而用大承气汤”。

少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜大承气汤。（335）

【解析】本条论述少阴急下证之二。

阳明病燥热伤津一般有三种形式：一是手足濇然汗出，或腋下出汗，或周身出汗，为“津液外渗”；二是小便频数，为“津液偏渗”；三是本条所说“自利清水，色纯青”，则为“津液下渗”。所伤之津，如卮之漏，势必及于少阴之阴，欲救少阴之阴，必须泻下胃肠燥结之实。本证“自利清水，色纯青”而不夹粪便，又称之谓“热结旁流”。燥热结实，故“心下必痛”而拒按；少阴阴液耗伤，津液无以上承，故口舌干燥。燥结不去，则旁流不止，津液进一步涸竭，必有亡阴脱液之险。故用大承气汤急下以救阴。

少阴病，六七日，腹胀不大便者，急下之，宜大承气汤。（336）

【解析】本条论述少阴病急下证之三。

少阴病，六七日不愈，邪气入深，见腹胀满不大便，属阳明腑实证。燥热腑实不解，必灼伤少阴之阴。但阴伤之见证，本条并未举出，据前两条所述，可知口燥咽干等证自不可少。正如汪苓友所说：“此条病实承上二条口燥咽干之证而言，以故系之为少阴病，否则与阳明病实无以别矣”。

总而言之，既言少阴病，就必然以气血、阴阳不足为前提，张仲景在阳明、少阴两病分别设三个急下证，其用意至深。他示人在辨证论治的过程中，既要看到邪气，也要顾及正气，应做到祛邪而不伤正，扶正而不碍邪。三急下证，祛邪是手段，护正是目的。急下之所以可以存阴，全在于病为里实。若里无实热，则泻下之法不仅不能存阴，而反能伤阴。观急下诸条，均言“宜”大承气汤，其中包含有斟酌、推敲之意，这也告诉人们要随时根据正气与真阴的情况而选用适当的攻下方药。例如后世的增液承气之法，有时则较单用大承气汤急下存阴更为稳妥。

少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。（337）

【解析】本条论述少阴病治应急温的原则。

肾为先天之本，总司一身之阳气，若少阴阳气一衰，则周身阳气也必随之而衰，从而就形成全身性的虚寒病证。少阴病寒化证，若见脉沉而不起，则阳衰的苗头已露，而恶寒、身蜷、四逆诸证将相继出现，已势在必然。此时少阴的寒证真象已大白，应当机立断，积极救治，速以四逆汤“急温之”。若观望等待，贻误病机，以致下利清谷，躁烦，脉不出，或阴盛格阳、里寒外热等险证出现，则往往给治疗带来严重的困难。张仲景的这种见微知著，治中有防，防患于未然的积极措施，体现了预防为主，即“治未病”的思想，很值得借鉴。

少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之。若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也，急温之，宜四逆汤。（338）

【解析】本条论述阳郁痰实与阳虚寒饮的证治。

“饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐”，说明病在膈上。弦脉主饮，迟脉主寒，脉见弦迟有力，反映胸中有寒实之邪。胸中寒痰实邪郁遏胸中阳气，使阳气不达四末，故见“手足寒”。由于胸中寒痰留饮的阻格，所以饮食入口则吐，但又不能畅快地吐出，此外，寒痰实邪填塞胸中，每有上趋之机，故还可见到如第174条所述的“胸中痞鞭，气上冲咽喉不得息”等证。此属寒痰阻滞胸中的实证，“病在上者，因而越之”，故治以瓜蒂散涌吐在上之实邪。

若少阴阳虚，胸阳不振，则寒饮不化上停于胸膈，而见干呕欲吐之证，同时还可伴有四肢厥逆，下利清谷等证。寒饮之证，治应温化，故急用四逆汤温少阴之阳而化寒饮之邪。

本条二证虽皆与少阴阳衰有关，但一为寒痰实邪郁阻膈上，为有形之邪非攻不去，故用瓜蒂散吐之；一为阳虚失运，寒饮之气弥漫胸中，则非温而不化，故用四逆汤温阳化饮。

少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣；反少者，当温其上灸之。（339）

【解析】本条论述少阴虚寒下利，阳虚气陷的证治。

少阴病，虚寒下利，脉见微而涩，微为阳气虚，涩为津血少。阳虚而阴寒上逆，故呕；阳虚而卫外不固，故汗出；阳虚不摄而气陷，故大便频数，但由于津血虚少，化源不足，无物可下，所以大便次数虽多，但泻下之物却反甚少。本证由于少阴阳衰，以致虚寒下利日久，进而造成阳气下陷，阴液渐涸之重证，然考虑到津伤因于阳衰，有形之阴液不能速生，而无形之阳气则必所先固，故“当温其上灸之”，以温阳消阴，急救于顷刻，然后方容煎煮汤药以固阳摄阴。以灸何穴为宜？根据注家意见及临床经验，如百会、关元等穴均可选用。

【小结】

本篇原文共45条，前20条是少阴病的总论，论述了少阴病的脉证提纲、寒盛亡阳、火劫伤阴、治疗禁忌以及少阴病的生死预后问题。

后25条为少阴病的各论，其内容大致分阳虚寒化证与阴虚热化证两类，重点在于论述阳虚寒化证，诸如对四逆汤证、通脉四逆汤证、白通汤证、白通加猪胆汁汤证、附子汤证、真武汤证等的辨证分析，皆很详

尽，后世的补火派，即是在此基础上发展起来的。少阴病的热化证，多是阴虚阳亢，水不敌火为患，如阴虚火旺的黄连阿胶汤证和阴虚有热，热与水结的猪苓汤证等，临床时应注意鉴别使用。

咽痛，为少阴病的特有证候，亦可以看做是少阴经证的反映。少阴三急下证要和阳明三急下证结合起来研究，这样就可以明白仲景一从邪气立论，一从正气出发，而互文见义的用心。

少阴主心肾而司水火，心为一身之大主，肾为阴阳之根本。因此，少阴病常关系到生命的存亡，故临证不可等闲视之。尤其是在治疗阳衰寒化证时，更是宜急不宜缓，只要抓住疾病的苗头，就应积极采取有力措施予以急温。而急温之法，又以灸法最为方便且易求速效，故全篇以灸法收尾，则有其深刻的含义在内。

辨厥阴病脉证并治法

【概说】

厥阴病，是伤寒六经病证的最后阶段。“厥”有极的意思，如《素问·至真要大论》所说：“厥阴何也？岐伯曰：两阴交尽也”，因此，病至厥阴，则阴寒盛极。但根据阴阳学说的观点，物极必反，物穷则变，也即《素问·阴阳应象大论》所谓“重阴必阳，重阳必阴”，“寒极生热，热极生寒”的道理。当阴阳对立的双方发展到“极”的阶段，往往可以向其相反的方面转化。阴寒盛极，则阴尽而阳生，其中每有阳气来复的机转。而厥阴则正具备了阳气来复的条件，其一，厥阴与少阳相表里，其中孕育着少阳生发的一阳之气；其二，厥阴本身体阴而用阳，藏阴贮血，而内寄相火。在厥阴病阴寒盛极的情况下，相火则处于既伤且抑的地位，一旦阴寒由盛极而转衰，相火由伤而转复，就会以不可阻挡的势力而暴发出来，此即所谓“郁极乃发”，从而就使证情发生了根本的转折。正由于这两个因素的存在，所以厥阴为病每有阳复的机转。

厥阴包括足厥阴肝和手厥阴心包，它们分别与足少阳胆和手少阳三焦为表里。肝藏血，主疏泄，性喜条达。心包为臣使之官，代心而行令。

厥阴病的成因，有自传经而来者，如三阳病失治或误治，或太阴、少阴病不愈，均有可能传至厥阴；也有外邪直中，而使本经自病者。根据临床观察，前一种情况似为多见。

由于厥阴病在阴寒盛极之时每有阳气来复之机，所以其病常常是阴中有阳，而仲景则以寒热错杂的证候来反映这一特点，例如论中把“消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食”等寒热错杂之证，作为厥阴病的代表证候，即是此意。厥阴病又有阴阳胜复的特点，论中则以手足厥冷与发热的日数多寡作为判断阴阳盛衰的依据。除上述寒热错杂、厥热胜复之证以外，厥阴病尚有阴寒过盛的寒证，它以手足厥冷和下利为主要见证；也有阴寒退却，而阳复太过的热证，它以口渴，下利后重，呕而发热为主要见证。此外，因厥阴肝脏，而主疏泄，所以厥阴为病也往往出现气郁之证。亦可因肝的疏泄不利，进而影响脾胃气机的升降失调，而见呕吐、哕、下利等证。

厥阴病的治疗，则应根据具体病情施以不同的治法。寒者宜温，热

者宜清，而寒热错杂者，则当寒温并用兼而治之。

厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蚘，下之利不止。（340）

【解析】本条论述厥阴病的提纲证。

厥阴之为病，如见上热下寒的寒热错杂证，乃是反映了厥阴阴尽而阳生，阴阳转化的病变特点。厥阴为风木之脏，内夹少阳相火，风火相扇，消灼津液，使脏燥无液而求救于水，故见消渴。这里的“消渴”，是指渴而能饮，饮而又渴的一种证候，并非多饮多尿的消渴病。厥阴肝木挟少阳相火之气上冲，故见“气上撞心，心中疼热”。热则消谷善饥，寒则运化不利而不能食，故“饥而不欲食”正是上热下寒，寒热错杂的表现。由于内夹虚寒，进食亦不能得到腐熟消化，反致胃气上逆而作呕吐；若其人内有蛔虫寄生，因蛔虫闻食臭而出，故可见到“食则吐蚘”的情况。既然病属寒热错杂，治则当寒温并用。医生若只见其热而忽视其寒，误用苦寒清下之药，则必更伤脾胃，使下寒更甚，而见下利不止；当然，若只见其寒而忽视其热，误用辛热祛寒之剂，也会更助上热以灼津，从而使消渴为更甚。

对本条作为厥阴病的提纲证，注家是有争议的。大部分注家认为，本条上热下寒之证，能够反映厥阴病阴阳胜复、寒热错杂的特点，因此可以作为厥阴病的辨证纲领。如《医宗金鉴》就持这种意见，认为“厥阴者，为阴尽阳生之脏，邪至其经，从阴化寒，从阳化热，故其为病，阴阳错杂，寒热混淆也”，故“此条总言厥阴为病之大纲也”。也有人认为本条虽然列于篇首，但作为本篇的提纲证，亦仅是反映了上热下寒、寒热错杂的证候，而不能包括厥热胜复和寒厥热厥等的厥阴病证，故作为全篇之辨证纲领是不太妥当的。这两种意见，均可资参考。

厥阴中风，脉微浮，为欲愈；不浮，为未愈。（341）

【解析】本条以脉象辨厥阴病欲愈和未愈。

本论《辨脉法》说：“凡脉大、浮、数、动、滑，此名阳也；脉沉、涩、弱、弦、微，此名阴也。凡阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死”。今厥阴为风寒之邪所伤，则必发为阴寒之证，而脉当见沉微之象。如果沉微之脉逐渐浮起，而呈微浮之象，则标志着阴寒之邪逐渐衰退而阳气逐渐恢复，是阴转阳的好现象，故其病“为欲愈”。如果脉沉微而不浮起，则表明阴寒之邪未衰而阳气尚未恢复，故其病“为未愈”。

厥阴病，欲解时，从寅至卯上。（342）

【解析】本条论述厥阴病欲解的时间。

厥阴中见少阳而与少阳为表里，少阳为一阳之气，旺于寅卯辰三时。从寅至卯上正是少阳之气从生发到旺盛的时间，故此时厥阴得阳气之相助，而为其病欲解的最有利的时机。

厥阴病，渴欲饮水者，少少与之，愈。（343）

【解析】本条论述厥阴病阳气来复的口渴证治。

厥阴病出现口渴欲饮水者，不外三种情况：其一，厥阴病寒热错杂、上热下寒出现的“消渴”是渴欲饮水、饮而复渴，这种口渴的程度比较严重；其二是厥阴病阳复而太过，阳热亢盛，灼伤津液，而口渴引饮；其三是厥阴病邪退阳复的渴欲饮水，因阳气乍复，津液一时不及上承，因而口渴。此时的口渴绝非是“消渴”和“大烦渴不解”的一类，而仅仅是“渴欲饮水”罢了。故其治亦不需药物，只要少少与水饮之，以资助其津液，使阴阳自和，其病自可痊愈。若饮水过多，恐阳气初复，不能化气行水，而反造成停饮之证，因此也不宜过多饮水。

诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。（344）

【解析】本条论述虚寒厥逆之证禁用攻下之法。

“诸”，在此处为发语词。“四逆”，即四肢逆冷，在此仅指手足厥冷而言。致厥的原因，虽寒热虚实皆有，但以阳虚阴盛之厥为多见，因阳气虚衰或元气衰微所致，属于虚寒之证，故不可用攻下之法。

本条不仅限定了“四逆厥”不可下的范围，即指的是阳虚寒厥，同时若引申其义，推而广之，“虚家”虽不见厥者亦不可下之。

伤寒先厥，后发热而利者，必自止。见厥复利。（345）

【解析】本条论述厥热与下利的关系。

厥阴病，以阴阳胜复、寒热错杂为其病变特点。阳气胜则发热；阴气胜则厥逆。而阴胜之厥逆又大多与下利伴见，厥回则利止，厥发则利作。“伤寒”，是说病从伤寒而来。寒邪盛而阳气微，阳为阴抑，不能充实于四肢，故四肢厥冷；阳气虚而不能腐熟运化水谷，所以常伴有下利。先是厥利并见，而后见发热，是阳气来复，阴寒消退的征兆，故预断其下利“必自止”。如果在利止之后，而又出现四肢厥冷的，这是阴霾四合、阴气又盛，必将再次出现下利，故曰“见厥复利”。这种厥与热，利与不利的反复发作情况，在临床上是比较罕见的，但以厥热与下利之间的内在联系及辩证关系，来说明寒热胜复、阴阳消长的病机变化，却是很有现实意义的。

伤寒始发热，六日，厥反九日而利。凡厥利者，当不能食，今反

能食者，恐为除中，食以索饼，不发热者，知胃气尚在，必愈，恐暴热来出而复去也。后三日脉之，其热续在者，期之旦日夜半愈。所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，与厥相应，故期之旦日夜半愈。后三日脉之而脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也。（346）

【解析】本条论述以厥热胜复判断疾病之进退的方法，以及除中的辨证。

病从伤寒而来，开始发热六日，随之手足厥冷并伴下利九日，这种先热后厥，厥多热少的现象，说明此厥属于阳气衰微，阴寒内盛。阳衰阴盛，气虚下陷，腐熟运化无权，故多伴有下利的证候，即所谓“厥反九日而利”。大凡手足厥冷而兼下利的阴寒之证，由于寒邪伤及脾胃，中焦受纳、运化失职，多见食欲减退之证。而今却能食的，故用“反”字。这恐为胃气将绝的“除中”现象。是否属于“除中”？可令病人吃索饼（即面条一类的食物）以验之。若食后不发暴热而只见微热，则为胃气尚在，中气复苏，古人说：有胃气则生，乃是疾病转危为安的佳兆，故曰“必愈”。说明“今反能食者”并不是除中。所谓“除中”，是胃气败绝的一种证候。因胃热则能食消谷，胃寒则不能食。然而，当胃气败绝、虚阳欲脱之际，有时因残灯复明，病人竟可出现能食的反常现象。但进食之后，每多出现暴热，而病人则往往随暴热之去而死亡。因为死于中气的消除，故名“除中”。也有食后无暴热而仅有微热者，如果微热能持续三日以上，则可预断三日期满的次日夜半病将获愈。因夜半少阳之气起，人得天阳相助，故有获愈之机。“所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，与厥相应，故期之旦日夜半愈”，这是作者的自注句，借以说明厥热相等，阴阳均衡，故其病当愈。如果后三日切其脉数，观其证仍为热不止，则为阳复太过，即“热气有余”的表现。若阳热之邪腐灼阴血，则其后必发痈脓之变。

本条以厥热胜复反映正邪斗争、阳气盛衰的状况，并以此判断厥阴病的进退。但临床又当结合病人的其他临床表现，如能食与不能食，脉数与脉迟等等加以综合分析，才能得出疾病进退的正确诊断。

伤寒脉迟，六七日，而反与黄芩汤彻其热。脉迟为寒，今与黄芩汤，复除其热，腹中应冷，当不能食；今反能食，此名除中，必死。（347）

【解析】本条论述伤寒脉迟下利，禁用寒凉药物的原则，及对误服寒药变成“除中”的原因分析。

“伤寒脉迟”主太阴脾寒，必有下列，医不用理中之法，致使拖延至

六七日之久，按传经的一般规律，当为厥阴受邪之际。厥阴虚寒之下利证而乍见阳复发热的现象，然下利未止为阴寒之邪未解。医者不察，反以苦寒之黄芩汤彻其热，以致更伤阳气，使阴寒益甚。中阳不足，故“腹中应冷”；脾胃腐熟运化机能失职，故“当不能食”。而今服黄芩汤后却出现了能食的反常现象，这种反常现象乃是胃气暴然而脱的前奏，是胃气将绝，借谷气自救而强食的一种反映，故属“除中”，而必死无疑。

本条给人以下两点启示：一是治疗三阴寒证，不但要密切注意先天肾阳的强弱，同时也要顾及后天脾胃阳气的盛衰。因为胃乃三阴之屏障，为水谷之海，气血化生之源，属后天之本。胃气之存亡，关系到人体生命之安危，即有胃气则生，无胃气则死。所以保胃气，特别是保护脾胃的阳气，亦为治疗虚寒证的根本原则之一。二是三阴虚寒性下利，即使有发热的现象，若不是阴寒内盛，迫阳外越的真寒假热证，便是阳气乍回的佳象，千万不要滥投寒凉之药，以致出现“除中”的死证。

伤寒先厥后发热，下利必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉为痹。发热无汗而利必自止，若不止，必便脓血。便脓血者，其喉不痹。（348）

【解析】本条论述先厥后热，阳复太过的变证。

伤寒先出现手足厥逆而后出现发热的现象，是厥阴虚寒证而有阳气来复，故虽伴见下利，亦必能自止。如阳复阴消，厥回利止，阴阳平和，其病即可告愈。但若阳复太过，热气有余，则又可形成阳热变证，并随邪热侵犯的部位不同，而发生不同的病证。阳热之邪向上向外蒸迫津液外泄，则汗出；熏灼咽喉，使咽喉红肿疼痛，则可形成喉痹；阳热之邪向内向下，则发热而不汗出；寒利虽可自止，却可变为热利，邪热灼伤下焦阴络，则必大便脓血。因厥阴属肝，肝主藏血，故肝热伤阴又每有动血之患。阳热之邪下趋而不上扰，喉痹证则不会发生，故曰“便脓血者，其喉不痹”。

伤寒一二日，至四五日而厥者，必发热，前热者，后必厥，厥深者，热亦深，厥微者，热亦微，厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。（349）

【解析】本条论述热厥的证治及病势轻重的推断与禁忌。

病由伤寒而来，起病一二日至四五日即见发热，手足厥冷。虽然文字叙述是热在前，厥在后，即“前热者，后必厥”，但实际上此证的特点是在周身高热的同时而见手足厥冷，故称为“热厥”。身热而手足厥冷的发病机理是阳热郁遏不能外达，阳盛于内、格阴于外，阴阳气不相顺

接，故发为手足厥逆。厥的微甚与热的轻重有着相应的关系，即“厥深者，热亦深；厥微者，热亦微”。也就是说，从外见厥逆的深浅轻重，可推断内伏阳热的深浅轻重，如阳热郁伏的愈深重，则手足厥逆亦必然愈甚。

这种热厥证在临床上每多见于小儿，在外感高热的同时伴有手足厥冷，且热势的高低与厥冷的程度成正比。

由于热厥是邪热内闭，阳郁不伸，故当以泻下之法破阳行阴，使阳气得伸，阴阳之气得以平衡、协调、顺接，则厥热自解。所谓“厥应下之”，临床应灵活看待，“下之”也可看做是泛指寒凉药物破阳行阴之法的概括，它既包括通下之法，也包括苦寒清热之法。《内经》说：“酸苦涌泄为阴”，即指广义的下法而言，并非局限于“泻下”一法。

若医者误以为发热是表邪未解，而用麻黄、桂枝之辛温发汗之法，非但解决不了阳热之郁，相反辛温之品会助长阳热之邪上攻，而致口伤烂赤。

纵观以上条文可以看出，形成厥逆的原因很多，其中也有阳热致厥的一面，因此厥逆一证，应分清其属寒或是属热。一般热厥的特点是先发热，后见厥，厥热并见，同时应伴有心烦、口渴、舌红、苔黄、便秘、尿黄赤、脉沉实或滑数等特点。而寒厥则多伴有下利清谷、恶寒身蜷、脉沉微、但欲寐、舌质淡等阴寒证象。辨证明确，立法用药才能中的。

伤寒病，厥五日，热亦五日；设六日当复厥，不厥者，自愈。厥终不过五日，以热五日，故知自愈。（350）

【解析】本条论述厥热相等其病自愈的道理。

伤寒病至厥阴，阴盛阳衰，阳虚不达四末，则必手足厥冷。如果厥五日，而后又发热五日，说明阴寒虽盛，而阳气犹存，阳气能与阴寒抗衡而不示弱。假使阴寒之邪胜于阳气，则应以第六日复厥为凭，但事实上厥并未出现，因此预示其病当愈。因为厥五日，热亦五日，厥不能超过热，乃是阴寒之邪衰退而阳气又能力争的反映，阳进而阴退，故知其病当自愈。

凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷是也。（351）

【解析】本条总结厥的成因和其表现特点。

“厥”包括两类证候，或者说有两种含义：一是指猝然昏倒，不省人事的一类病证，如尸厥、煎厥、薄厥等；二即指本条所说的“手足逆冷”

是也”。然临床所见，有些病证则往往是昏厥与手足逆冷的证候同时并见。

手足逆冷之厥，只是一个症状，引发的原因却有很多，如因于寒、因于热、因于气、因于痰水、因于蛔虫等等，但是无论什么厥，其致病的根本成因，不外阴阳二气的不相顺接。阳受气于四肢，四肢为诸阳之本。人的手指、足趾伸侧为阳经，屈侧为阴经，三阴三阳经脉皆在手足交接，而使“阴阳相贯，如环无端”，即阴阳气互相顺接，此为生理之常。若阳虚不达四末，则独阴而无阳，手足得不到阳气的温煦则发生厥冷，此为“阴厥”或叫“寒厥”。若阳热内盛，郁伏于里，而格阴于外，亦能造成阴阳气不相顺接，而发生手足逆冷，此为“阳厥”或叫“热厥”。若由于肝郁气滞，气机不利，阳气被阻遏不达四末而致手足逆冷者，则称为“气厥”，如此等等。总之，厥证虽多，但其病机则一，即均是“阴阳气不相顺接”所致。

伤寒，脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁，无暂安时者，此为藏厥，非为蛔厥也。蛔厥者，其人当吐蛔。令病者静，而复时烦，此为藏寒。蛔上入膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者，蛔闻食臭出，其人当自吐蛔。蛔厥者，乌梅丸主之。又主久利方。（352）

乌梅丸方：

乌梅三百个 细辛六两 干姜十两 黄连一斤 当归四两 附子六两，炮 蜀椒四两，去子 桂枝六两 人参六两 黄蘗六两

上十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五升米下，饭熟，捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜，杵二千下，丸如梧桐子大，先食饮，服十丸，日三服，稍加至二十丸。禁生冷、滑物、臭食等。

【解析】本条论述蛔厥病的证治。

在伤寒发病过程中，出现脉微而手足厥冷的证候，是阳虚阴盛的反映。至七八日寒邪愈甚则阳气益虚，致使其人不但手足厥冷不回，而且周身皮肤亦同时发凉并伴有肢体躁动不安乃至没有片刻的安稳之时。这是因为其人阴寒过盛、阳气虚极，既不能温煦肢体，也不能充养精神所致。此病叫作“藏厥”，乃是纯阴无阳的危候，而不是“蛔厥”，两者不能相混。

蛔厥与脏厥最大的不同之处，是“蚘厥”有呕吐蛔虫的特点，即“蚘厥者，其人当吐蚘”。“当”者，常也，言其人素常就有吐蛔虫的历史。再者，蛔厥之“厥”与脏厥之“厥”在表现上也有所不同，后者为手足持续厥冷，前者的手足厥冷往往不能持续，而是当蛔虫上扰，发生吐逆、心烦、疼痛之时，则出现厥逆。“令病者静”的“令”字乃是“今”字之误。蛔厥病人见烦而不躁，且只是在蛔动上扰时才烦，不上扰则安静，即时烦时止，此又与脏厥“其人躁，无暂安时者”截然不同。

蛔厥的病理变化为其人“藏寒”，即肠胃有寒。蛔虫有喜温畏寒的习性，为避寒就温而“上入膈”，所以其人发烦。若蛔不上扰，其烦即止，所以这种烦是暂短的，即所谓“须臾复止”。病人进食，蛔闻食味又会上窜，扰于膈上则复烦，影响胃气不和则呕吐，蛔虫亦可随之而吐出，故“其人当自吐蚘”，即常自吐蛔。

本证反映了厥阴病的基本病理变化，即由于厥阴疏泄不利，气机失调，以致寒热格拒上下，阴阳气不相顺接，并进而影响脾胃不和，升降失常。这种上热下寒，寒热错杂的蛔厥证，当治以寒温并用，和胃安蛔，滋肝敛阳的乌梅丸为主。乌梅是方中主药，用醋浸则更益其酸，味酸入肝，能生津液、益肝阴、止烦渴、涩肠止泻安蛔；当归补血养肝，与乌梅相伍，可养肝阴，补肝体；附子、干姜、桂枝温经回阳以制其寒；辅以川椒、细辛，味辣性散，通阳破阴，制伏蛔虫；黄连、黄柏泄热于上，并驱蛔虫下行；人参益气、健脾，培土以制肝木。用米饭、白蜜甘甜之品作丸，不仅养胃气，且可作驱蛔之诱饵。全方寒温并用，攻补兼施，以其酸以退蛔，以其辛以伏蛔，以其苦以下蛔，从而达到驱蛔之目的。

本方用于治蛔厥（类似现代医学所谓胆道蛔虫症）有极好疗效。除此之外，还可用于治“消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食”的厥阴寒热错杂证。由于本方寒热并行、补泻兼施，又有乌梅之酸敛固涩，再得米饭保胃气之助，故对寒热虚实夹杂的久利而滑脱不固之证，也有治疗作用。此外，临床用本方治疗肝胃不和、肝脾不和的吐呕、下利等证，也有比较显著的疗效。

伤寒，热少厥微，指头寒，默默不欲食，烦躁数日，小便利，色白者，此热除也，欲得食，其病为愈；若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。（353）

【解析】本条论述热厥轻证及厥热胜复的转归。

伤寒，病至厥阴，见发热而厥，是属热厥。“热少厥微”，说明邪热势轻，为热厥轻证。由于阳热闭郁不甚，故厥微而不甚，仅表现为“指

头寒”而已。因有郁热，故当见烦躁，小便短赤。厥阴肝郁影响胃气不和，故见“默默不欲食”。数日之后，若小便短赤而变为“小便利，色白”的，则是里热已除，津液得复的反映。郁热得除，气机通达，胃气和降，故从默默不欲食，一变而欲得饮食，则其病为愈。如果数日后不见小便利，欲得饮食等现象，而见厥逆加重，并伴有呕吐、胸胁烦满等证，说明厥阴邪热未解，反而郁结较前更甚。邪热郁久不解，则必伤及阴络而动血，发生便血的变证。

病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。（354）

【解析】本条论述厥阴经脏皆寒的证候。

病人手足厥冷，言“我不结胸”，是作者用以说明病不在上焦又见小腹胀满，按之疼痛，则提示病在下焦，属阳虚寒凝所致。厥阴肝的经脉“过阴器，抵小腹”。今手足厥冷，小腹胀满，按之则痛，乃厥阴经、脏皆寒，阳气衰少，寒凝气滞，不能温运所致，故曰“此冷结在膀胱关元也”。关元穴在脐下3寸，膀胱亦在此处，故称“膀胱关元”是泛指小腹迤带而言。本条未出治法，据情当用当归四逆汤加吴茱萸、生姜以温经腑之寒。有的注家认为，本证为少阴虚寒，冷结膀胱，当治以四逆、白通之属，或用真武汤温阳利水以祛寒邪。如尤在泾就说：“手足厥冷……若不结胸，但少腹满，按之痛者，则是阴冷内结，元阳不振，病在膀胱关元之间，必以甘辛温药，如四逆白通之属，以救阳气而驱阴邪也。”此说可作参考。

伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多，其病当愈。四日至七日，热不除者，其后必便脓血。（355）

【解析】本条论述厥阴病阳复而病愈及阳复太过而不愈的变证。

文中所说厥、热的日数多少，主要用来对比说明阴阳消长、盛衰变化的问题。例如：伤寒发热四天，厥冷三天，又发热四天，显系热多于寒，即所谓“厥少热多”，反映了阳能胜阴的病机，故其病当愈。若发热从第四天乃至第七天仍不除的，则为阳复太过，亦并不为美。阳者，热也，因肝主藏血，故当阳热不除，热气有余之时，每多有热并于阴，灼伤阴络，而发生大便脓血的变证，这也是厥阴病的病变特点之一。

伤寒厥四日，热反三日，复厥五日，其病为进，寒多热少，阳气退，故为进也。（356）

【解析】本条与上条对比，论述厥阴病阴盛阳衰则为病进。

手足厥冷四天、发热三天，复又厥冷五天。从厥与热日数的对比来

分析，显然是厥多而热少，表明疾病在继续发展，故谓“其病为进”。为什么厥多热少，其病为进呢？张仲景在文中作了说明，即“寒多热少，阳气退，故为进也”。这里的寒热，代表疾病的性质，而前之厥热则代表疾病的证候。所谓“寒多热少”，是以病情变化推断出来的，先厥四日，复厥五日，合计为九日，而发热只有三日，对比之下，显然是寒多热少。热者阳也，寒者阴也。寒多热少，表明阴盛阳衰，即“阳气退”。伤寒以阳气为本，现阳气退，故其病为进。

伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦躁，灸厥阴，厥不还者，死。
(357)

【解析】本条论述厥阴病阴盛阳亡的死证。

伤寒六七日不愈，病至厥阴，脉见微象，证见手足厥冷，乃为阴邪肆虐，阳气衰微的表现。阳虚阴盛，不相顺接，故“脉微”而“手足厥冷”。阳气衰微，阴寒过盛，阴来搏阳，弱阳与强阴相搏，所以又见“烦躁”。阴寒重证所出现的“烦躁”证，往往是亡阳的危候。值此危急关头，当立即采取急救措施，若以药扶阳抑阴，又恐为时过缓无济于病，故急灸厥阴，一般常选用太冲、大敦，并配合任脉的关元、气海等穴以回阳消阴为急务。若灸后阳气来复则手足转温，若灸后手足厥冷仍不还者，则为阳气已绝，难以救治，故曰“死”。

伤寒发热，下利，厥逆，躁不得卧者，死。(358)

【解析】本条论述厥阴病阴极阳亡的死证。

厥阴虚寒证见发热，若属阳气来复，当利止厥回，今虽见发热，但利仍不止，而厥不回，说明发热非为阳复，而是阴寒盛极，逼阳外越的格阳证候。阳气浮越不敛而有外亡之险，故其人躁扰不得卧寐，这是病情的一个方面。此外也可理解为虚寒下利日久，不但伤阳，也要耗阴，阴液涸竭，则阳气浮越不敛，亦同样会出现发热、躁不得卧等证。总之，凡在下利厥逆的同时，更见发热、躁不得卧者，均属阳气欲脱、阴阳离决的危证，故主“死”。

厥阴病发热，有阳复和阳亡两种不同病情，应注意加以辨别：若阳复之发热，其厥利必随之而自止，是邪退正复的好现象；若亡阳之发热，则其下利厥逆不止，这是里真寒而外假热、阴盛格阳的危象，此时若再出现躁不得卧，是阳气完全发露于外，而行将外脱的凶兆，预后多属不良。

伤寒发热，下利至甚，厥不止者，死。(359)

【解析】本条论述阴盛亡阳而下利至甚的死证。

厥阴病见发热，但下利却日趋严重，甚至发展到“下利至甚”的程度，而且四肢也厥逆不止。说明这种发热是阴盛格阳，残阳欲亡的危象，而绝非阳气来复之佳兆。“下利至甚”，则是阴寒至极，下元不固的反映。“厥不止”，也即四肢厥逆不还，则为阳气不续之所致。阴盛而阳亡，故属死证。

伤寒六七日，不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。（360）

【解析】本条论述阴盛亡阳汗出不止的死证。

伤寒有六七日之久，原来不下利，而后又出现发热而下利，说明病情有变。那么如何判断病势的进退呢？一般说伤寒先有厥逆下利，后见发热而利自止的，则是阳气来复、寒邪消退的欲愈现象。现在发热与下利同时并见，可知“发热”非为阳气之来复，而是阴盛格阳、孤阳外越的假象。如果此时其人更见汗出不止，则是阳气外亡而不固，阴阳本是相互依存的，今阳气外亡，阴阳离决，终致“有阴无阳”，而多难救治，故主“死”证。“有阴无阳故也”，是作者对死因的自注。

伤寒五六日，不结胸，腹濡，脉虚，复厥者，不可下，此为亡血，下之死。（361）

【解析】本条论述厥阴病血虚致厥的脉证及治疗禁忌。

伤寒五六日，如果邪热传里，与痰水结于胸腹成为结胸病，其人必见脉沉紧、心下坚满疼痛等证；如果邪热内传阳明敛结成实，其人必见腹满疼痛拒按、不大便等证。然从“不结胸，腹濡，脉虚”则可知其证既非结胸，也非胃实。至于手足厥逆之证，乃是由于“亡血”之所致。所谓的“亡血”之证，据本论第401条所说：“恶寒脉微，而复利，利止，亡血也”，可知其多指虚寒下利的阴液伤亡证而言。其证本为阳虚，四末失温，故见“厥逆”。又有津伤亡血，大肠失润，或见大便秘结。因亡血属虚证，故虽有大便秘结，亦不能使用下法，若误下，则为“虚其虚”，使气亏血竭，预后必然不良，故曰“下之死”。

发热而厥，七日，下利者，为难治。（362）

【解析】本条论述厥阴病厥热下利的难治之证。

厥阴病厥热往复，反映着正邪斗争，阴阳进退的力量对比。如果发热属阳气来复者，则厥利当止。今发热、厥逆至七日而更见下利，说明阴寒之邪过盛，而阳气不支，欲从外脱。乃阴进阳退，正不胜邪，故病为难治。

以上数条，列举了诸多死证，而本条所述是为难治之证，其间有何

联系，又有何不同？张隐庵对此做了阐发，他说：“此节乃通承上文死证之意，而言发热而厥至七日而犹然下利者，病虽未死，亦为难治。上文言死证之已见，此言未死之先机”。其说可资参考。

伤寒脉促，手足厥逆者，可灸之。（363）

【解析】本条论述阳虚脉促而厥逆的可灸之法。

这里的“脉促”，指脉来急促。伤寒见促脉，有虚实寒热之分：促而有力，为阳气盛，主热；促而无力，为阳气虚，主寒。本条脉促与阳虚不温四末之手足厥逆并见，则应是促而无力之脉，故主虚主寒。阳虚阴盛，阴来搏阳，虚阳奋力与阴寒抗争，故脉急促而无力。脉来急促是假象，按之无力才是本质。其治可用灸法，酌选关元、气海等穴灸之，扶阳固本以祛阴寒。

有的注家认为，此之脉促，为数而中止之促脉，如尤在泾说：“脉阳盛则促，阴盛则结，手足厥逆而脉促者，非阳之虚，乃阳之郁而不通也，灸之所以引阳外出”。考虑厥阴肝主疏泄，若厥阴病疏泄不利，气机不畅，阳气闭郁不通，而见脉促、手足厥冷，看来也不是没有道理的。至于本文之脉促究属阳虚还是阳郁，临证时全面观察脉证，不难作出判断。

伤寒脉滑而厥者，里有热也，白虎汤主之。（364）

【解析】本条论述热厥的脉证与治法。

滑脉主阳，多见于阳盛或邪实之证。伤寒手足厥逆而见滑脉，知非虚寒，而属里热阳郁。邪热深伏，阻遏阳气不达四肢，而使阴阳气不相顺接，故手足厥冷。此因里有热而致厥，是谓“热厥”，亦称“阳厥”。所谓“里有热”，即指热郁阳明。阳明既热，虽四肢厥冷，但胸腹灼热、烦渴饮冷、汗出等证，亦意在言外。本条只言脉象，并以脉断证，可知此之脉滑，实为热厥辨证之眼目。脉滑说明里有热，但并未敛结成实，故其治宜清不宜下。用白虎汤既可清解阳明郁热，又可生津养液，使里热清，阴阳和，则厥逆自解。

上条所言脉促而厥，是属阴寒盛，其治当灸；本条所论脉滑而厥，是属里热盛，其治当清。两条虽然都有脉数而手足厥冷的共同见证，但仔细推敲，疾病的性质却完全相反，治疗的方法也截然不同。两条并列论述，实有相互对比和鉴别的意义。

手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。（365）

当归四逆汤方：

当归三两 桂枝三两 芍药三两 细辛三两 大枣二十五个 甘草二两，
炙 通草二两

上七味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【解析】本条论述血虚寒厥的脉证治法。

“手足厥寒”，即手足厥冷，若与脉微欲绝同见，则属阳衰阴盛之证，其治当用四逆汤回阳救逆；若与脉细欲绝同见，则细主血虚，故属血虚感寒，以致阴阳气不相顺接而成血虚寒厥，其治当用当归四逆汤养血通脉，温经散寒。

当归四逆汤用当归配芍药补肝养血以调荣；用桂枝、细辛通阳疏肝以散寒；桂枝配归、芍又可调和营卫气血；大枣、甘草补脾胃、生津液，兼制细辛之过散；而通草通利阴阳以利血脉。

少阴阳虚寒厥与厥阴血虚寒厥，同属里虚寒证。但由于病机不同，其治疗也不相同。少阴重在真阳，以阳虚为主，故治用四逆汤大辛大热之品，药少力专，回阳宜急；而厥阴主藏血，体阴用阳，故重在养血以滋肝，而忌辛燥之品以劫其阴，所以用当归四逆汤以归芍养血柔肝，并取其药多义广，善能温通血脉的作用。

经验证明，当归四逆汤可用于治疗多种疾病，如“雷诺综合征”见肢端麻木厥冷疼痛，其脉细者；亦治较严重的冻疮疼痛、疝气痛、妇女痛经、血栓闭塞性脉管炎、痹证关节痛及头目牵引作痛等等，凡属血虚有寒或厥或痛皆可选用，并每能获得满意疗效。

若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤主之。（366）

四（赵本四上有“当归”二字）逆加吴茱萸生姜汤方：

当归二两 芍药三两 甘草二两，炙 通草二两 桂枝三两，去皮 细辛
三两 生姜半斤，切 大枣二十五枚，擘 吴茱萸二升

上九味，以水六升，清酒六升，和煮取五升，去滓，温分五服。一方水酒各四升。

【解析】本条承上条，论述血虚寒厥兼内有久寒的治法。

血虚寒厥治以当归四逆汤，已如上述。“若其人内有久寒者”，“内”指内脏而言，包括肝或肝胃等脏器；“久寒”，指沉寒痼疾，表现为下焦积冷，少腹冷痛，或中焦寒饮呕吐，脘腹疼痛等证，治宜当归四逆加吴茱萸生姜汤养血通脉而经脏两温。

本方方名“四逆加吴茱萸生姜汤方”前脱“当归”二字，应按赵本补正。当归四逆加吴茱萸生姜汤。即在当归四逆汤养血通脉、温经散寒的基础上加吴茱萸、生姜暖肝散寒、温胃化饮，更用“清酒”煎药，以增强其温通散寒的效力，达成经脏两温之效。

大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利，厥逆而恶寒者，四逆汤主之。（367）

【解析】本条论述阳虚厥利，真寒假热的证治。

此证有大汗出，热不去，若是阳明里热外蒸，可见身热、汗出，热不为汗衰，但绝不见厥利恶寒等证。今大汗出，热不去，又见下利厥逆而恶寒等证，可知不是里热，乃属阴盛格阳，阳欲外亡的危候。阳虚阴盛至甚时，则阳被阴逼不能潜藏于里而亡失于外。虚阳外越，阳被阴格，故而“大汗出，热不去”。它既不同于阳明病的高热汗出、烦渴引饮，又有别于表证发汗的热随汗解。阳气虚则寒必盛，寒主收引，故腹内有拘急疼痛之感。四肢为诸阳之本，阳虚阴乘，寒滞筋脉，故见四肢疼痛。阳虚寒盛，温煦失职，所以又下利厥逆而恶寒。通观全文，本证当属阳虚寒盛，寒邪浸淫于内、虚阳浮越于外的危候，因此要急用四逆汤回阳救逆。

以上两条，虽都有厥逆一证，但当归四逆汤主治脉细血虚有寒之厥；四逆汤主治下利恶寒阳虚阴盛之厥。一在养血，一在温阳，主治各有侧重，而不可混用。

大汗，若大下利而厥冷者，四逆汤主之。（368）

【解析】本条论述阳虚阴盛而厥冷的证治。

大汗出或大下利，不仅伤阴，更可伤阳。今大汗、大下利之后出现厥冷，知为阳气大伤，阴寒内盛所致。此时虽无虚阳外越的发热证，亦当急以四逆汤回阳救逆。正如喻嘉言所说：“此条较上条无外热相错，其为阴寒易明。然既云大汗大下利，则津液亦亡。但此条不得不以救阳为急，俟阳回尚可徐救其阴”。因本证之津伤来自于阳虚，故可不救阴，而以四逆汤温阳，阳气得复，则气化行、阴液自生。“大汗，大下利”在这里既可看做是导致伤阳的原因，又可理解为阳虚不能固摄的病变结果，实含有双重意义。

病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中。心中满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。（369）

【解析】本条论述胸中痰实致厥的证治。

“病人”泛指患病的人，包括了伤寒、杂病在内。病人在手足厥冷发作时，切其脉乍然而紧，究其原因，乃为痰食有形之邪凝结在胸中所致。脉紧主实，痰实有形之邪凝结于胸中，故其脉见乍紧。实邪阻遏胸阳，使阳气郁而不达四末，故手足厥冷。实邪郁遏，气机不畅，故见“心中满而烦”。既然“邪结在胸中”，为何又见“心中满”？其原因有二：一是因本证之邪实，原包括寒痰与宿食之类，故邪结的部位当包括心下与胃脘。二是即使邪结胸中，也必然影响中焦气机之升降，而见心下满闷不舒。胸中有实邪阻滞，故虽知饥但又不能食。因其病位高，本着“其高者，因而越之”的治疗原则，当用瓜蒂散涌吐在上之实邪。实邪得去，胸阳畅达，气机通利，则手足厥冷、心下满而烦诸证自解。

伤寒厥而心下悸者，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥；不尔，水渍入胃，必作利也。（370）

【解析】本条论述水停心下而致厥的证治。

伤寒见厥，有因寒、因热、因痰实结于胸中等原因，但本条的手足厥冷同时伴有心下悸动，知其致厥的原因是水饮内停之故。因水停胃中，胃阳被水寒所抑，阴来搏阳，故心下悸动。阳气被水饮阻遏，不能通达于四肢，阴阳气不相顺接，因而手足厥逆。证属水停中焦，阳被阴抑，故其治当先用茯苓甘草汤以治其水。水饮去，则胃阳布，悸动止而手足自温。若不先治其水，则水饮下渍胃肠，可导致下利的发生，即所谓“水渍入胃，必作利也”。由于下利则愈损其正气，正虚又将加重水寒之势而使病情恶化，故张仲景提出“宜先治水……却治其厥”的法则。从诸多水饮病来看，虽以阳虚为本，水饮为标，但当以水证为主时，为防再虚其阳而罹生他患，故亦当先治其标。经验证明，通过温阳化饮利水的治疗，使阳气得以振奋伸发，厥证每可得到改善或解除。从这个意义上说，温阳化水之法实寓有治本的积极作用在内。但也有注家认为：先治有形之水，后治无形之寒，其说亦可参考。上条论胸中痰实，阻遏胸阳，使阳气不能达于四末而致厥，当治以瓜蒂散吐之，实邪去，阳气达，厥逆随之而解；本条论胃中停水，阻遏中阳，使阳气不达于四末而致厥，当先治其水，后治其厥。而临床当用茯苓甘草汤，俾水邪去，阳气通，其厥也每能获愈。

茯苓甘草汤方义，在“太阳病篇”第74条已述，此不赘述。

伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽

喉不利，唾脓血，泄利不止者，为难治。麻黄升麻汤主之。（371）

麻黄升麻汤方：

麻黄二两半，去节 升麻一两一分 当归一两一分 知母 黄芩 萎蕤各十八铢 石膏碎，绵裹 白术 干姜 芍药 天门冬去心 桂枝 茯苓 甘草炙，各六铢

上十四味，以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服，相去如炊三斗米顷，令尽，汗出愈。

【解析】本条论述寒热错杂，唾脓血泄利的证治。

伤寒六七日，本为邪气内传之时，但若表不解，则仍当解表。即使邪气化热入里，若尚未构成阳明胃家实证，也不能误用攻下之法。今医者用大下之法，故实属误治。误下后，正气受伤，上焦阳热之邪内郁，因此寸脉沉而迟，尺部脉不起；阳虚气抑，不达四末，阴阳气不相顺接，因而手足厥逆。阳热郁于上，痹阻咽喉，灼伤络脉，所以咽喉不利而吐脓血；误下伤正，下焦有寒，因而泄利不止。此上热下寒，气阴两虚，寒热虚实杂糅之证。如治寒则遗热，治热则妨寒，治实则碍虚，补虚则助实，故“为难治”。而麻黄升麻汤实可清上温下，发越阳郁，滋阴和阳，故用之最为适宜。

麻黄升麻汤用麻黄、升麻透发内陷的阳郁之邪，升麻兼以升举下陷之阳气；用黄芩、石膏、知母清肺胃在上之热；用桂枝、干姜以温中通阳；用当归、芍药以养血和阴；用天冬、萎蕤以养阴生津、滋补阴液不足；白术、茯苓、甘草健脾补中、交通上下之阴阳。本方宣发阳郁之邪，滋补脾胃之阴，温养下后阳气之虚。虽主治寒热错杂，但偏重于宣发升散，故以麻黄升麻为方名。

本方用药的特点是：药味多，以适应病情之复杂；剂量小，以利于阳郁之发散。在药味多、剂量轻的前提下，麻黄、升麻的剂量相对为大，从而突出了本方以宣发为主的治疗作用。通过药后的宣散汗出，不仅使内陷之邪得以外透，且使表里上下之阳气得以通达，阴阳水火能得以交通既济，则使其病得愈。方后注云“汗出愈”，可见其重点乃在于透邪外出。

对于本方，历代注家争议颇多，有人认为非仲景方，亦有人认为此方没有实用价值，当废弃不用。从理论与实践两方面去分析，上述看法皆有不全面之处。因为《伤寒论》是一部完整的、充满辩证思想的巨著，统观全书篇与篇、节与节、条文与条文之间，无不首尾相接，前后

呼应，有机相联。尤其它辨证论治的思想体系更具系统性与完整性。书中所载112方也都是实践经验的结晶，具有很高的实用价值，绝非似是而非，有无两可之属。仅从其治疗寒热错杂证来说，全书总结出了几个大法：其中有乌梅丸的寒热并用，重点在于酸敛收纳之法；有黄连汤的寒热并用，重点在于和中之法；下文即将提到的干姜黄连黄芩人参汤的寒热并用，重点偏于苦降之法；也包括麻黄升麻汤的寒热并用，重点在于宣发之法。虽然各种方法如收、和、宣、降各有侧重，但它们都是有效地治疗寒热错杂证的一个重要的组成部分。如果将麻黄升麻汤废弃，则其治法将是有降而无升，有收而无宣，这就破坏了《伤寒论》辨证论治体系的完整性，这是其一。唐代医学大家孙思邈的千金萎蕤汤，从其方药组成和治疗作用看，与麻黄升麻汤有某些近似之处，或者说是从麻黄升麻汤发展演变而来，而千金萎蕤汤的治疗作用及临床疗效，是被后世医学所肯定的，因此麻黄升麻汤也并非没有价值，这是其二。第三，陈逊斋医案载，用本方治李梦如子喉病兼下利而获效。因此，无论在理论上或实践上，本方的作用和价值都是不容置疑的。当然对本方还有待于我们在今后的临床实践中进一步研究与探讨，使之得到更好的继承和发扬。

伤寒四五日，腹中痛，若转气下趣少腹者，此欲自利也。（372）

【解析】本条论述寒性下利的前驱证候。

伤寒四五日，多为邪气传里之时，若脾阳受伤，升降失常，则易出现虚寒下利之证。但在下利欲作之先，患者自觉腹中有气从上而下抵至少腹，或闻漉漉有声，此即“转气下趣少腹”之候。每当腹中之气下行时，也常常伴见腹中疼痛。阳明病的胃家实证，因肠中有燥屎，亦可见腹中痛、转失气之证，但失气虽下而燥屎却不下；脾虚寒证腹中痛，而见转气下趣少腹，则于转气之后，必随之而泻利发作。其证一实一虚，迥然不同。

伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格，更逆吐下；若食入口即吐，干姜黄连黄芩人参汤主之。（373）

干姜黄连黄芩人参汤方：

干姜 黄连 黄芩 人参各三两

上四味，以水六升，煮取二升，去滓，分温再服。

【解析】本条论述“寒格”的证治。

伤寒本因寒邪而下利，医者误以为实热而用吐下的方法治疗，从而使里气更虚，气机不利，脾胃升降失常而致寒热格拒。胃阳被格而逆于上，则“食入口即吐”；脾阳被抑而清气不升，则下利更甚。因此病“本自寒下”，而又误治伤阳使寒者更寒，上热被下寒所格拒，而中焦不能斡旋交通，故称之为“寒格”。

呕吐有寒热之分，一般说，因于寒者多表现为朝食暮吐、暮食朝吐，因于热者，则多是“食已即吐”。本证食入口即吐，当属热证。但由于这种热是来自于吐下后的寒格，因而热只表现在上，而在下者仍还是寒。上热下寒，故吐利交作，治宜干姜黄连黄芩人参汤清上温下。

干姜黄连黄芩人参汤用黄连、黄芩苦寒以泄上热，干姜温脾以祛下寒，人参健脾补虚，以复中焦升降之能。本方寒热并用，苦降辛开，干姜又可从其上热，引导芩连入内，使之不发生格拒，所以，陈修园认为此方也治火邪上逆的呕吐，如把干姜改为生姜则更有疗效。

下利，有微热而渴，脉弱者，今自愈。（374）

【解析】本条辨厥阴虚寒下利而见阳气恢复向愈的脉证。

厥阴虚寒下利，若见恶寒蜷卧，脉阴阳俱紧者，是阴盛阳衰而为病进。今见“微热而渴”，说明阳气渐复，“脉弱”虽主正气不足，但也反映邪气转衰，阳复阴消，正复邪却，故其病可不治自愈。

下利，脉数，有微热汗出，今自愈；设复紧，为未解。（375）

【解析】本条承上条，再论厥阴虚寒下利有自愈与病未解的脉证。

脉数主阳、主热。厥阴虚寒下利，见脉数，是阴病见阳脉，表示阴邪退而阳热来复，同时“有微热汗出”，说明阳气通达，而又非阳热太过之证，故为疾病向愈的佳兆。“设复紧，为未解”，是说假设虚寒下利而又见紧脉，紧脉主寒为邪气盛，说明寒邪势盛而未衰，正气不能驱邪外出，此时虽有微热汗出等证，也多属寒盛阳亡之候，病亦不能自愈。

下利，手足厥冷无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者，死。（376）

【解析】本条论述厥阴厥逆无脉的危证。

厥阴虚寒下利，阳气虚不足以温煦四末，故手足厥冷；血气不续，故而无脉。阴阳皆虚，病势险急，当采取急救措施，可灸气海、关元、大敦、太冲等穴位，以回阳为急务。如果灸后手足温而脉还的，说明阳气尚未至竭绝的程度，故生机尚在，还有救治的余地。若灸后手足不

温，脉搏不至，说明心肾根本之阳虚极，此时若再见微喘，为肾阳不能纳气归根，故病属危殆，而预后不良。

少阴负趺阳者，为顺也。（377）

【解析】本条承上条，以少阴趺阳脉之胜负而论证病之顺逆。

“少阴”与“趺阳”，在这里系指脉位而言。上条言“无脉”，是指上部寸口脉不至，而本条之少阴与趺阳脉则指在下之足部脉。少阴为肾脉，其部位在太溪穴；趺阳为胃脉，其部位在冲阳穴。少阴肾为先天之本，阳明胃为后天之本。若病重上部无脉，当诊察下部根脉。“少阴负趺阳”，即太溪脉小于趺阳脉。而趺阳脉盛，则胃气不衰，有胃气则生，其病虽重，仍可救治，预后较好，故“为顺也”。反之，若趺阳负于少阴，即趺阳脉小于少阴脉则表明胃气败绝，已无法救治，故属逆证，脉以胃气为本有其临床意义。

下利，寸脉反浮数，尺中自涩者，必清脓血。（378）

【解析】本条论述厥阴热利的脉证。

脉浮数为阳，虚寒下利，见浮数之脉，是阴证见阳脉，表示阳气来复，其病向愈。今下利，病在里，寸脉反见浮数，尺中见涩脉，是阳热有余，阴血反受热伤的征象。厥阴肝主藏血，热伤阴络，腐化为脓，所以“必清脓血”。

下利清谷，不可攻表，汗出，必胀满。（379）

【解析】本条论述阳虚里寒证，不可攻表发汗。

“下利清谷”，本为脾肾阳虚，不能腐熟水谷所致，当急以四逆汤温里回阳，即使兼有表证不解者，亦不可发汗以攻其表。因为汗乃阳气蒸化津液而成，发汗不仅伤津，而且也损阳气，阳气外泄，则在里之阳更虚。阳虚则寒凝气滞而发生胀满。

下利，脉沉弦者，下重也；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热不死。（380）

【解析】本条论述厥阴病下利的几种不同脉证及预后。

厥阴下利，有寒热之分，从证见“下重”来看，是指痢疾而言。厥阴为肝之病，肝主疏泄，喜条达。肝气郁结，则气郁化热；气机不畅，则湿邪内蕴。湿热交结，迫注大肠，热性急迫而湿性缓滞，加之肝失疏泄，因此大便下重难通，肛门有重滞之感。湿热互结于里，故脉沉；利属厥阴，故又脉弦。

《素问·脉要精微论》云：“大则病进。”所以下利而“脉大者”，为邪

气盛，病势在继续发展，故“为未止”。若下利脉微弱而数者，表明邪热已衰，主下利欲自止，此时若见发热，则是正气不衰之象，故“虽发热不死”。言外之意，当下利、脉大有力而又见发热不止者，则为邪热亢盛，病势继进，预后多不良。

下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒，汗出而解，病人必微厥。所以然者，其面戴阳，下虚故也。

（381）

【解析】本条论述戴阳轻证有郁冒作解之机。

下利清谷，脉沉而迟，是为虚寒病证。阳虚阴盛，虚阳外越，可发生格阳、戴阳。“其人面少赤，身有微热”，说明阴寒势减，格阳不甚。阴寒之邪由盛变衰，因而其证也相应地必见微厥。既然真阳未尽浮露而外脱，尚能潜藏于里，阴寒邪势又由盛转衰，所以阳气尚有抗邪之机，阳气与阴寒抗争，则其人出现郁冒之证；阳气来复，通达内外，驱邪外出，其人则汗出而病解。“所以然者，其面戴阳，下虚故也”，这是自注句，说明面少赤，身有微热的戴阳证，是因于下虚而阳不潜敛；下利清谷，脉沉迟，手足厥逆，则是因于下焦阴寒之盛。下焦寒盛，格阳于上，则其面戴阳而发赤。

本条的“戴阳”，仅是微热，面少赤，反映阳气虽虚，但未尽浮露，尚有奋起与阴邪相争的潜力，此与少阴病所论及的“少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤”的阴寒极盛、阳虚至极而阴阳即将离决的危重病证则有很大的不同。本证为戴阳轻证，故有郁冒汗出自解之机；前者则为戴阳的重证，如不借助药力，则绝无自解的可能。

下利，脉数而渴者，今自愈；设不差，必清脓血，以有热故也。

（382）

【解析】本条论述厥阴寒利由于阳复太过，而转为热利便脓血之证。

寒性下利若见“脉数而渴”，是阴寒退却，阳气恢复，阴证转阳的好现象，故其病当自愈。假若阳复太过而化热，则邪热可灼伤阴络，而致大便脓血，其病则不能愈。

本条说明，厥阴寒利，若见脉数而渴者，有两种不同转归：一为阳复寒却，疾病向愈；一为阳复太过，阳热有余而反有便脓血之患。

下利后脉绝，手足厥冷，晷时脉还，手足温者生，脉不还者死。

（383）

【解析】本条论述下利脉绝的预后。

“脉绝”即脉来不继，断绝无脉之意。下利后见“脉绝，手足厥冷”，多是阴津阳气暴脱，以致脉搏不续、阴阳气不相顺接所致。阳气乍脱，若根本未败，仍存有来复的生机。若经过晬时，即24小时，脉搏逐渐还复，手足转温，说明阳气来复，故主生；若经过24小时脉仍不还，手足仍然厥而不温，说明阳气已败，已绝来复之机，故主死。

这里需要说明三个问题：一是脉为血之府，脉搏的形成，不仅需要血液的充盈，而且需要阳气的鼓动；下利不仅伤津，而且也损阳。故脉绝反映了阴阳气血俱不足，若与手足厥冷并见，则当以阳虚为主。二是本证阴阳气血俱虚，属新利之暴虚，故脉绝尚有复还之机；若久利不止以致阳气磨灭殆尽，则脉绝鲜有复还之机。三是察脉之还与不还，所以要按晬时计算，可能与人体机能恢复有一定的联系。陈修园指出：“生死之机，全凭于脉，而脉之根，又借于中土也。夫脉生于中焦，从中焦而注于手太阴，终于足厥阴，行阳二十五度，行阴二十五度，水下百刻，一周循环，至五十度而复大会于手太阴，故脉还与不还，必视乎晬时也。”此说可供参考。

伤寒下利，日十余行，脉反实者死。（384）

【解析】本条论述虚证见实脉者死。

伤寒下利，一日十余次，致气血津液大伤，此属大虚之证，当见微细无力的脉象，方为脉证相应，病虽重亦可救治。今大虚之证，反见实而有力的脉象，脉证不符，故脉实言“反”，说明其人正气大虚，而邪气则反盛实。正虚邪实，难以救治，故为死证。

脉实还有脉失柔和的意思，即所谓真脏脉见。下利日十余行不止，正气本已虚甚，再见真脏脉，表明胃气败绝，故主死。

下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。（385）

【解析】本条论述阴盛格阳的证治。

“下利清谷”，是脾肾阳虚，阴寒内盛，腐化无权所致。阳虚不温四末，所以见厥。阳虚不固而欲从外脱，故见汗出。在此一派阴寒的证情下，若又见身热，则既非表热不解，亦非阳复之热，而是阴盛格阳、阳气欲亡的表现，故仲景揭示此证曰：“里寒外热”，也就是真寒假热。其治当急以通脉四逆汤回阳救逆，以挽回欲脱的阳气。

本方证在少阴病已作过介绍，学习本条时当与少阴病有关条文相互联系对照，则更有助于理解。

热利下重者，白头翁汤主之。（386）

白头翁汤方：

白头翁二两 黄柏 黄连 秦皮各三两

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升；不愈，更服一升。

【解析】本条论述厥阴热利的证治。

厥阴下利有寒热之分，“热利下重”，指出热利每有下重的特点，所以它是热利的主证。厥阴热利，多为湿热内蕴，气机不畅，因而表现为里急后重，下重难通之象。“下重”既是湿热下利的一个重要特征，也是厥阴热利的辨证眼目。厥阴肝主藏血，热迫血分，灼伤阴络，腐化为脓，故便脓血是厥阴热利的另一个特征。从以上下重、便脓血两证来看，厥阴热利实际上包括了现代医学所说的痢疾病。治用白头翁汤清热燥湿，凉血止利则愈。

白头翁汤以白头翁为主要药物，白头翁苦寒，善清肠热、治毒痢，并能凉血舒肝，为治毒热赤痢的要药；黄连、黄柏寒以清热，苦以燥湿，最能厚肠止利；秦皮苦寒，能清肝胆及大肠湿热，并可凉血坚阴而止利。

本方不仅治菌痢，亦可治阿米巴痢疾。只要是属于肝经的湿热下利，见有里急后重，便脓血等证者，无论病程长短，一般说都是有效的，但是对于温病伤阴的阴虚下利，见舌红无苔或舌中有裂者，则非本方所宜。

曾治一妇人，自诉下利，腹痛，脐腹部有冷气感。初辨为下焦有寒，气血不和，用桂枝加芍药汤治疗，不料服一剂竟腹痛加重，以致痛不可耐。详察其舌红苔腻、脉弦且数，下利尚有里急后重之感，小便短少黄赤，乃悟此证实为厥阴湿热下利。先令服六一散10克，再服白头翁汤，仅一剂而病愈。此案是比较典型的厥阴热利证，因有湿热内蕴，热为湿裹，气郁不伸，故脐腹部反有寒冷的感觉，临证勿被其惑。

下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里四逆汤；攻表桂枝汤。（387）

【解析】本条论述虚寒下利兼有表证的治疗法则。

腹胀满有因于实者，也有因于虚者。腹胀满，大便不通，多属实；腹胀满与下利并见则多属虚。《灵枢·经脉》云：“胃中寒则胀满”，今下利，腹胀满，是因脾肾阳虚，温运失职，寒凝气滞所致。脾肾阳气虚衰，腐熟运化无力，其下利必为完谷不化。“身体疼痛”说明表证未解。里虚又兼表证，其治当“先温其里，乃攻其表”，即先用四逆汤温里扶阳，待里气恢复，清便自调，抗邪能力增强之后，再拟桂枝汤以攻表。这是治疗表里同病，而里气虚的一个法则。若不遵循这个法则，先行攻表，误发虚人之汗，则可造成亡阳虚脱的严重后果。张景岳对这一治疗法则作了很精辟的分析：“此一条乃言表里俱病而下利者，虽有表证，所急在里，盖里有不实，则表邪愈陷，即欲表之，而中气无力亦不能散，故凡见下利中虚者，速当先温其里，里实气强则表邪自解，温中可以散寒，即此谓也。”

下利，欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。（388）

【解析】本条继论厥阴热利的证治。

虚寒下利一般不渴，即或有渴，如少阴病自利而渴，亦多不欲饮水。今“下利，欲饮水”，而口渴能饮，说明是热伤津液，故曰“以有热故也”。因热而下利，则属热利，厥阴热利，必见里急后重，便脓血。其治仍应以白头翁汤清热燥湿，凉血止利。

本条提出的“下利，欲饮水”，是对厥阴热利见证的又一补充。综合以上几条，可知辨厥阴热利当抓住三个主证，即下重，便脓血，口渴欲饮水，由此方知其证为热而非寒。

下利，^评语者，有燥屎也，宜小承气汤。（389）

【解析】本条论述燥实内阻，热结旁流的证治。

下利因有燥屎所致者，是属热结旁流。其所利下之物，多是“自利清水，色纯青”，或是大便黏液，滞下难通。由于本证的关键在于“有燥屎”，以致腑气不通，气滞不爽，故其证也多见腹满疼痛，口燥咽干等证。热结阳明，浊热扰心，故而^评语。治当通因通用，以下其结，方用小承气汤。

曾治一患者，下利黏秽，里急后重，脉沉滑，舌苔黄厚。初用白头翁汤治疗，证情似有好转，但未得愈，舌苔黄厚则有增无减。遂认为肠中尚有积滞未化而改用小承气汤泻下。药后黄苔去，下利止而病愈。

本条设此处，其意有三：一是承上条补充热利的另一治法；二是有与厥阴之热利鉴别比较的作用，厥阴热利以下重、便脓血为主，而本证

当以腹痛拒按，^评语为主；三是本证虽是阳明有燥屎，但其病源又可因于厥阴病阳复太过，阳热伤津化燥，以致燥热成实。也就是说，本证的形成与厥阴病有着密切关系。

下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜栀子豉汤。（390）

【解析】本条论述邪热蕴郁心胸的证治。

此之下利，本为热利，下利腐秽得去，邪从下泄，故按之心下濡。但利后余热不尽，蕴郁于心胸，故烦不减而更甚。因为这种引起心烦的郁热，只是无形的热邪，未与痰、水、食等有形之邪结聚，故称之为“虚烦”。治用栀子豉汤的清宣，以解胸膈间的郁热。

本条列于厥阴诸下利证之后，对利后余证的辨证论治有重要意义。若本为热利，而余热不尽，郁扰胸膈而致虚烦者，可治以栀子豉汤；若原为虚寒下利，由于阳复太过，虽下利止而又发生虚烦者，亦可酌用栀子豉汤治疗。

呕家有痈脓者，不可治，呕脓尽自愈。（391）

【解析】本条论述因内有痈脓而呕者，当治其内痈。

“呕家”，指素有呕吐的病人。致呕的原因很多，有因外感的，有因内伤的，有因寒的，有因热的，有因蓄水的，有因痰食涌逆的，亦有因内痈蓄脓的等等。其治当察其所属，究其所因，辨证以论治，不可见呕止呕。本条所述之呕家，乃是因内脏生痈脓而致呕吐。此为肺、胃热毒内蕴而生痈脓，痈脓既成，每多借呕吐以排出，因此呕吐又是排泄秽物、驱邪外出的一种正常反应，故凡痈脓已成需要排出而见呕吐者，绝不可止其呕，所谓“不可治”，即不可单纯止呕之意。“呕脓尽自愈”，是说将脓液排尽则呕自止，并非指病痊愈。若要从根本上治呕，则当从治痈脓入手。使内痈愈，而脓不生，则呕吐必不治而自止。这就是“治病必求其本”的意义。

呕而脉弱，小便复利，身有微热见厥者难治。四逆汤主之。（392）

【解析】本条论述呕而手足厥冷属阴盛格阳，故为难治。

“呕而脉弱”，为病在里。因“小便复利”，故可排除水饮为患。脉弱为正气不足，病在厥阴而见弱脉是阳气虚衰。见身有微热而手足温者，是阳气来复的佳兆。今身有微热而手足厥冷，说明非为阳复，而是阳不胜阴，阴寒之邪内盛而格阳于外的反映。其呕亦属阴盛阳衰，阴阳格拒，阴寒之气上逆的见证，故其病为难治。当急以四逆汤扶阳消阴，以

观后效。

干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。（393）

【解析】本条论述肝寒犯胃的证治。

厥阴肝脉，挟胃属肝，上贯膈，布胁肋，上入颞颥，连目系，上出与督脉会于巅顶。寒伤厥阴，下焦浊阴之气循经上犯于胃，致使胃寒气逆，水饮不化，而见“干呕，吐涎沫”，即口中频频地吐出清涎冷沫，或如蛋清，或如白沫，或如清水。厥阴肝寒循经上逆，故见头痛且以巅顶部为甚。其治当以吴茱萸汤暖肝温胃降浊以散水饮。

吴茱萸汤证在《伤寒论》中，涉及阳明、少阴、厥阴三经的病变。从其方证分析，肝胃虚寒当为病变的根本。既是肝胃虚寒，为何又列入少阴病中？因为少阴肾阳为一身阳气之本，因元阳之气根于肾，必由肝胆而升，借三焦之通路以布于周身，温煦五脏六腑、四肢百骸。而胃为中土，乃是心肾水火上下相交的必由之路，故若肝胃虚寒，则必然影响少阴阳气的升腾与心肾阴阳的交通和水火的既济。前述少阴病烦躁欲死，即是中寒为病而影响心肾不交的见证，可见厥阴、阳明二经均与少阴有着密切的关系。

呕而发热者，小柴胡汤主之。（394）

【解析】本条论述厥阴病脏邪还腑，转出少阳的证治。

肝与胆相表里，少阳病进可转入厥阴，厥阴病衰也可转出少阳，故有实则少阳，虚则厥阴之说。本条所述厥阴病见喜呕而发热不退的少阳证候，是脏邪还腑、由阴变阳的好现象。临床上除见到呕而发热外，还可有口苦、心烦、脉弦等少阳病的其他见证。既然厥阴病已转出少阳，则当治以小柴胡汤和解之法。

伤寒大吐大下之，极虚，复极汗出者，以其人外气怫郁，复与之水，以发其汗，因得哕。所以然者，胃中寒冷故也。（395）

【解析】本条论述伤寒误用吐下使胃阳虚而致哕。

伤寒大吐大下而伤伐其正气，特别是脾胃之阳气，因而造成脾胃之气“极虚”，本不应再汗，而又“复极汗出”，以致其人外气怫郁于表，则身热不解。而医者认为表不解，而用热饮的方法，再度发汗。如此一误，而使胃气虚冷，故发生哕，即呃忒之证。“所以然者，胃中寒冷故也”。是作者借以说明致哕的原因与机理。

伤寒，哕而腹满，视其前后，知何部不利，利之则愈。（396）

【解析】本条论述哕而腹满的辨证与治法。

哕，即哕逆，俗称呃逆。致哕因素虽多，但概括起来不外虚实两类，而其病机，总由气机不利，胃失和降所致。今哕与腹满并见，一般多属于实证，虚实虽明，但仍需要进一步探讨证候形成的具体原因，以便制订相应的治疗措施，所以要观察其大小便，即“视其前后”，若小便不利，则为蓄水；大便不利，则为腑实。蓄水宜通利小便；腑实宜通利大便。查明前后何部不利，施以相应治法，使二便通利，气机调畅，则哕逆、腹满亦必随之而愈。

【小结】

本篇原文共56条。因病至厥阴，阴寒极盛，阳复有机，即所谓寒极生热，阴极生阳，故厥阴病与少阴病截然不同，而以寒热错杂、厥热往复、或寒、或热等证为特点。

厥阴寒热错杂证，治当寒热杂治。其中有乌梅丸寒热杂治，重在酸收以伏蛔；干姜黄连黄芩人参汤寒热杂治，重在苦降以止呕；麻黄升麻汤寒热杂治，重在宣发以透内陷阳郁之邪。

厥阴阴阳消长之机，可通过厥、热胜复之证而知。故本篇列举数条厥热对比，孰多孰少之证，以予辨别阴阳消长、推测预后作示范。

本篇又将诸厥证作了归纳。厥者，手足逆冷是也，是言其证；凡厥者，阴阳气不相顺接，是言其病机。并论述了四逆辈的阳虚寒厥；当归四逆汤证的血虚寒厥；白虎汤证的热厥；可下证的里热实厥；乌梅丸证、麻黄升麻汤证的寒热错杂厥；瓜蒂散证的痰阻胸阳厥；茯苓甘草汤证的水遏胃阳致厥等。

厥阴主肝，肝气疏泄失调，可致六腑气机不利、升降失常而出现诸多呕、吐、哕、下利之证。就呕吐而言，有吴茱萸汤证的肝胃气寒、浊阴上逆之呕；有小柴胡汤证的脏邪还腑、阴病出阳之呕；也有乌梅丸、干姜黄连黄芩人参汤证的寒热错杂、上热下寒之呕。就下利而言，有四逆辈的寒利；白头翁汤证的热利；小承气汤证的内结旁流；以及乌梅丸、麻黄升麻汤证的寒热错杂之利等。

厥阴为病，阴盛则寒，阳复则热。寒极亡阳则死；阳复邪却则愈；若阳复太过则热，其热上攻可发喉痹，下迫可便脓血，外壅肌肤则发痈脓。凡此种的不同预后，本篇均已述及。

辨霍乱病脉证并治法

【概说】

霍乱是以呕吐、下利为主要临床表现的暴发性的胃肠疾患。后世医家又根据见证不同，分为湿霍乱与干霍乱两大类：即上吐下利，吐泻无度者为湿霍乱；欲吐不吐，欲泻不泻，但见烦闷不安，腹中绞痛，短气汗出者，为干霍乱。本篇所讲的霍乱，因以呕吐而利为主证，故当属湿霍乱。

霍乱病，多因饮食生冷不洁，或感受六淫之邪，而使表里之邪相并，寒热错杂，乱于肠胃，清浊相干，升降失常所致。仲景把霍乱病列于伤寒六经病证之后，是作为类证以与伤寒鉴别比较而设的。

问曰：病有霍乱者何？答曰：呕吐而利，名曰霍乱。（397）

【解析】本条论述霍乱病的主要证候。

本条以问答形式，揭示了霍乱病的主证，并列于篇首，实有提纲挈领的作用。问：疾病中有称作霍乱的，其临床表现是什么？答：呕吐、下利且暴然而作者，即为霍乱。

霍，迅速、急骤之意；乱，即变乱之意。霍乱，即指暴然发作的疾患；霍乱以吐泻为主证，又含有挥霍撩乱的意思。因其发病急骤，吐泻交作，挥霍撩乱，故取名霍乱。此与现代医学所讲的由霍乱弧菌所引起的霍乱，概念不同，而其范围要广泛得多。早在《灵枢·五乱》中，就有了霍乱的名称，如“清气在阴，浊气在阳……清浊相干……乱于肠胃，则为霍乱”，并已明确指出了霍乱的病因、病机和主证。这在世界医学史上也远远居于领先地位，是值得大书而特书的。

问曰：病发热，头痛，身疼，恶寒，吐利者，此属何病？答曰：此名霍乱。自吐下，又利止，复更发热也。（398）

【解析】本条补述霍乱见证，并指出与伤寒的不同之处。

由于霍乱也是感受外邪引起，故亦可兼见表证，发热恶寒同时并见，是病在表；邪客于表，经脉不利，故头身作痛。病在表，若属太阳伤寒，只有当邪气内传，影响里气不和，脾胃升降失常之时，才见呕吐下利。今初病即见吐利并与表证同见，故不属伤寒而属霍乱。霍乱虽也是表里同病，但以吐利的里证为主。“自吐下”，即言病从内发，而不是

受表邪的影响。病从内而外，表里不和，则吐利、寒热并见；若下利止，但见发热，说明里气虽和，而表证未解。

伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日，至阴经上，转入阴必利，本呕下利者，不可治也。欲似大便而反失气，仍不利者，属阳明也，便必鞭，十三日愈，所以然者，经尽故也。（399）

【解析】本条论述伤寒与霍乱的脉证异同，而作了鉴别和比较。

伤寒表不解而又内传入阴经，则表里同病，亦可见身热、恶寒而吐利交作，证情类似霍乱。但若伤寒表不解，其脉必见浮紧。今初病即吐利，而脉反微涩，说明此证并非伤寒，乃“本是霍乱”为病。霍乱为病，“本呕下利”，发则吐利交作，速致津气大伤，故脉来微涩而无力。至于伤寒为病，则多是在四五日后邪传阴经之时，才见吐利。二者迥然有别，切不可将霍乱病误诊为伤寒而论治，此即所谓“不可治”之义。若霍乱吐利之后，其人欲似大便而不能，而仅见失气而已，此为吐下津伤化燥，胃肠失润所致，故曰“属阳明也”。因其并非传经之邪，故其病至十三日，当经气来复，津液得以恢复之时，则病可自愈。津伤转属阳明，虽大便必硬，但无其他腹满疼痛拒按、潮热、譫语等腑实燥热证候，故与阳明病的“胃家实”亦有所不同。

下利后，当便鞭，鞭则能食者愈；今反不能食，到后经中，颇能食，复过一经能食，过之一日，当愈。不愈者，不属阳明也。（400）

【解析】本条承上条，论述下利后的各种证候变化。

下利后，津伤失润，大便当硬。因不属阳明胃家实证，虽大便硬，但腑气尚通，胃气尚和，故能食而有自愈的机转。今初病即“不能食”，但“到后经中”，即过七日以后而“颇能食”的，反映胃气已逐渐恢复，如复过一经而继续能食，则过一日其病当愈，此与上条所述十三日病当愈之义相同。若到后经中不愈者，则不属津伤便硬之阳明，当考虑是其他的病证。

以上三条，可以说是本篇的总论。全面地论述了霍乱病的脉证特点和预后转归，并与伤寒病进行了鉴别比较，也对霍乱病的辨证论治提供了可靠的依据。从以上三条内容分析，可以看出霍乱和伤寒有以下几点不同：

1.病因

霍乱多是六淫与饮食杂糅之邪干于胃肠；伤寒则是邪客于表，由皮

毛而入，逐渐传里。

2.病机

霍乱是脾胃升降失常，清浊相干，胃肠机能紊乱，其病由内而外；伤寒则是皮毛受邪，营卫失和，其病从外而内。

3.脉证

霍乱初起即见吐利交作，脉来微涩；伤寒则是时过几日，邪转入阴，方见吐利。病初起，邪在表，脉来浮紧。

恶寒脉微，而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之。（401）

四逆加人参汤方：

于四逆汤方内，加人参一两，余依四逆汤法服。

【解析】本条论述霍乱吐利致阳虚液竭的证治。

“恶寒脉微”，本为阳虚，“复利”是阳虚阴盛，必见下利清谷。若利止而见烦、热、手足温、脉数者，是为阳复向愈之证；今利止而不见阳复脉证，可知并非阳复阴退，而是津液随下利而竭，已无物可下，此即所谓“利止，亡血也”，治以四逆加人参汤回阳兼救阴。

四逆加人参汤即四逆汤加人参。用四逆汤以回阳，人参既可益气固脱，又可生津滋阴。故本方用于亡阳虚脱而脉不起，以及阳损及阴、阴阳两伤者，最为妥当。如凡四逆而表现为大汗不止，吐利无度而致阴液消耗者，均可施用。《伤寒论》中，白虎汤证见大烦渴不止要加人参；通脉四逆汤证见脉微欲绝，利止脉不出者也要加人参；本条的利止亡血亦加人参，联系起来可见人参不仅益气，而且确有生津补液的作用。

霍乱，头痛，发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之；寒多不饮水者，理中丸主之。（402）

理中丸方：

人参 甘草炙 白术 干姜已上各三两

上四味，捣筛为末，蜜和丸，如鸡黄大，以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之。日三四，夜二服，腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法，以四物依两数切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

加减法：

若脐上筑者，肾气动也，去术加桂四两。吐多者，去术，加生姜三两。下多者，还用术。悸者，加茯苓二两。渴欲得水者，加术，足前成四两半。腹中痛者，加人参，足前成四两半。寒者，加干姜，足前成四两半。腹满者，去术，加附子一枚。服汤后，如食顷，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

【解析】本条论述霍乱兼有表证的治法。

既言霍乱，必暴然而作吐利，同时伴有头痛、发热、身疼痛等表证，则属表里同病，其治当根据表里寒热的不同病情而施以不同的治法。若以表证、阳证为主，即“热多”，见口渴欲饮水而小便不利者，则治以五苓散，表里两解，通阳化气，利小便而实大便，且五苓散又有行制节之令的作用，能升清降浊而调脾胃。若“寒多”的，即以寒湿之邪为主，见口不渴，“不用水”者，即“自利不渴，属太阴也”的互义。则治以理中丸，温化中焦寒湿。

理中丸用人参、甘草健脾益气；干姜温中散寒；白术健脾燥湿。脾阳得复，寒湿得去，则升降调和而吐利自止。本方为治太阴虚寒证的主方，因其作用在于温运中阳，调理中焦，故取名“理中汤”。本方又名人参汤，亦治虚寒性的胸痹证。本方煎服法，有几点需加以说明：

1.原为丸剂，亦可作汤服，为一方二法。病缓需久服者，可用丸；病急或服丸效差者，应用汤剂。

2.服药后腹中转热，是见效的反映，“腹中未热”不效，可加量；仍不效，更见腹冷痛、畏寒、手足冷、下利清谷者，可加附子而脾肾兼治。

3.为增强药效，温养中气，服药后可喝热粥，并温覆以取暖。

4.若是中焦虚寒下利，又夹热见大便黏液不爽者，可加黄连，为连理汤；兼胃寒吐逆不止，可加丁香、吴茱萸，为丁萸理中汤；兼吐蛔者，可加乌梅、川椒，为椒梅理中汤。随证加减，临床均有较好疗效。

吐利止而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。
(403)

【解析】本条论述霍乱里和表不解的证治。

霍乱可表现为表里同病。今“吐利止”，说明里气和，而“身痛不休”，说明表证不解。治“当消息和解其外，宜桂枝汤小和之”。消息，有斟酌之意，寓有灵活变通，随证选药的意思。为何用桂枝汤小和之？这是因为吐利之后，正气受伤，虽有表邪亦不可用麻黄汤类峻汗；再者，吐利之后，邪气已衰，也不需峻汗。此处用桂枝汤也不必啜粥及温覆取汗，可见所谓“小和”，尚有不令发汗之意。

吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。
(404)

【解析】本条论述霍乱吐利以致亡阳脱液的证治。

吐利交作，更见汗出，说明真阳大伤，阳虚不固而外亡。阳虚不温四末，则手足厥冷。津液随吐利而外泄，则其病必由阳而损及阴。阴阳两虚不温、不柔，则筋脉失养，故“四肢拘急”。阳气大虚，弱阳被盛阴格拒而外浮，所以在畏寒的同时又见身热。本证虽为亡阳脱液之证，但因其液脱源于亡阳，故当先固散亡的阳气，治以四逆汤，亦阳气固，则阴液敛；阳气复，则阴液生之义。

既吐且利，小便复利而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。(405)

【解析】本条论述霍乱吐利后致里寒外热的证治。

“既吐且利”，即吐利交作，病当属霍乱。吐利津伤，小便当少而不利；今见“小便复利而大汗出，下利清谷”，说明吐利伤及下焦肾阳，阳虚不能固摄津液，以致津液下走外泄；不能温暖脾土，以致下利完谷不化而澄澈清冷。虚阳被盛阴格拒而外浮，从而形成“内寒外热”的真寒假热证。阳虚液少，不能充盈血脉，故见“脉微欲绝”，而似有似无。此为阳虚阴盛之重证，可先用四逆汤回阳救逆以摄阴，如不效，再投通脉四逆汤亦意在言外。

吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者，通脉四逆加猪胆汁汤主之。(406)

四逆加猪胆汁汤方：

于四逆汤方内，加入猪胆汁半合，余依前法服；如无猪胆，以羊胆代之。

【解析】本条论述霍乱吐利致阳亡阴竭的证治。

“吐已下断”，指不再吐利，即吐利停止。若吐利止而手足转温，则是阳复欲愈的佳兆。今吐利虽止，更见“汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝”等证，说明此“吐已下断”并非阳复，而是吐利太甚，以致水谷津液涸竭，无物可吐而自止，无物可下而自断。阳气外亡，所以汗出而厥。阴阳俱虚竭，筋脉失养，血脉不滋，故见四肢拘急不解，脉微欲绝。治以通脉四逆加猪胆汁汤，在回阳救逆之中，兼以益阴和阳。

原书卷十为“四逆加猪胆汁汤”，赵本为“通脉四逆加猪胆汤”，应据赵本在“四逆”之前加“通脉”二字。通脉四逆汤可回阳散寒，通脉救逆。加猪胆汁有两个作用：一可益阴滋液，既可补益吐下之液竭，又可制姜附燥热劫阴之弊，此即所谓“益阴和阳”；二可借其性寒，以引热药入阴，可减少或制约阴寒太盛对辛热药物的格拒不受，此为反佐之法。

吐利发汗，脉平，小烦者，以新虚不胜谷气故也。（407）

【解析】本条论述霍乱病后胃虚，应注意饮食调养。

霍乱吐利发汗之后，胃气必伤。见“脉平”，即脉搏平和、正常，说明大邪已去，阴阳和合，病已向愈。仍有“小烦”，即微烦，是病后脾胃虚弱，未能节制饮食，进食多而不能消化，即所谓“新虚不胜谷气故也”。“新虚”，指大病初愈，胃气尚弱；“不胜谷气”指胃气弱而不能消谷。此不需用药，只要能节制饮食，注意饮食调养即可。

本条列于霍乱篇末，重申保胃气，存津液的防治法则，很有指导意义。

【小结】

本文共11条，前3条论述了霍乱病的脉证特点，预后转归，及与伤寒的主要鉴别点；后八条主要论述霍乱病的辨证论治。霍乱吐利轻证兼表且有水结者，可用五苓散；偏中焦虚寒，寒湿内盛者，可用理中汤。霍乱吐利，伤阳脱液，直至阳亡液竭，阴盛格阳者，可据情酌用四逆汤、通脉四逆汤、四逆加人参汤、通脉四逆加猪胆汁汤等。霍乱吐利止而里已和，尚有表邪不解者，可用桂枝汤小和其外。霍乱初愈，正气未复，节饮食，慎起居等调养之法，很为重要，不可不知。

从全篇来看，本论所述之霍乱，多属后世所称之湿霍乱，而且以证偏寒湿者居多。

辨阴阳易差后劳复病脉证并治法

【概说】

伤寒热病，基本近愈，但气血阴阳未平，经腑余热未了，此时若行房事，男病则易于女，名叫阳易；女病则易于男，名曰阴易。男女之病，交相传易，故名阴阳易。易，即交易、变易之意。

伤寒新愈，正气未复，起居作劳，因而复病，谓之劳复。也有强饮暴食，因而复病者，则谓之食复。

本篇在六经病脉证治之后，论述阴阳易、差后劳复，以及大病差后余热、遗寒、正虚诸般证治，示人应对病后调理予以足够重视，方能巩固疗效，以收全功。可谓寓意深刻，而匠心独具。

伤寒，阴阳易之为病，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者，烧裯散主之。（408）

烧裯散方：

上取妇人中裯近隐处，剪烧灰，以水和服方寸匕，日三服。小便即利，阴头微肿，则愈。妇人病，取男子裯当烧灰。

【解析】本条论述阴阳易证治。

阴阳易是与大病新差，余邪未尽之人性交，染易邪毒而致的一种病。因房事最易伤人精气，故发病即见“身体重，少气”等精气不足之证。阴分被伤，筋脉失养，则见“少腹里急，或引阴中拘挛”及“膝胫拘急”等证。伤寒余热之邪由阴传入，毒热由下向上攻冲，则见“热上冲胸，头重不欲举，眼中生花”等证。其治则以烧裯散导热下行，使邪毒从阴而出。

裯即裤裆，烧裯散方取内裤近隐处（即裤裆处）的那一部分，烧作灰用。从“取妇人中裯近隐处”一句体会，可见男子患此病者为多，而妇人病，则取男子裯裆烧灰。此物本草书未载，据古人介绍男女裯裆，浊败之物也。烧灰用者，取其洁净而又有同气相求、导邪外出之义。服后

或汗出，或小便利则愈。阴头微肿者，是所易之毒从阴窍而出，故肿也。其说可供参考。

阴阳易在临床上是否可以见到，用烧裊散有无疗效，曾为此请教过一些名老中医。山西省中医研究所已故名医李翰卿先生作了肯定的答复。他说，从后汉至今，尽管历代医家对此证此方都有所争议，但均没有全盘否定，而是一直在研究探讨。根据自己有限的临床所见，也确有其病，用烧裊散也确有疗效。李老先生以六七个典型病例说明阴阳易为病，临床表现有三个特点：一是头抬不起来，即“头重不欲举”，这是很突出的一个表现；二是“少腹拘急”抽搐且牵引阴中拘挛；三是全身乏力，倦怠少气。治用烧裊散而每每取效。李老的经验之谈，很值得重视。

后世有人把阴阳易分为寒热两类。有上述证候者为热型，用竹茹、天花粉、白薇送服烧裊散；有阳衰、肢凉、精神不振者为寒型，用四逆汤等送服烧裊散。这些具体用法，亦资临床参考。

本条一则告诉人们，伤寒大病差后，正气未复，邪气未尽，应忌房事，否则就有可能发生阴阳易。二是论述阴阳易的证治。而其中包含了防患于未然，有以预防为主的精神。无论伤寒、杂病，凡人病初愈，都应忌房事，若犯此忌，有的虽非阴阳易而属房劳复，即因房事而使旧病复发，也常有不良后果。病后慎养之法，不可等闲视之。医者也一定要叮咛病人谨慎调养。

大病差后，劳复者，枳实栀子豉汤主之。若有宿食者，加大黄如博碁子大五六枚。（409）

枳实栀子豉汤方：

枳实三枚，炙 栀子十四枚，擘 豉一升，绵裹

上三味，以清浆水七升，空煮取四升，内枳实、栀子，煮取二升，下豉，更煮五六沸，去滓，温分再服，复令微似汗。

【解析】本条为劳复证治举例。

大病初愈，正气未复，若劳作过多，则生阳热，使在经未了之热得以复燃，疾病复发。证见发热、心烦等证，即所谓“劳复”。从临床所见，劳复并非全因于劳动过力，就是一般的活动，诸如坐立较久，言谈过多等，都可导致劳复。治以枳实栀子豉汤利气清热除烦。若兼有宿食

者，则加大黄泻下食积。

枳实栀子豉汤，即栀子豉汤加枳实。用枳实宽中行气，栀子清热除烦，香豉透邪散热。清浆水又名酸浆水，即米饭用清水浸泡七日以上，待味变酸，水面起白花即成。用清浆水煎药，有清热、除烦、理气、宽中、助消化的作用。若有宿食者，加大黄如围棋子大者五六枚，以荡涤肠胃，导滞下积。因而本方亦可用于病后食复之证。

临床所见，大病差后，因劳作不慎，而病劳复；因饮食不节，而病食复，均不少见。其他如结核病、肝硬化腹水等病，经治疗得以缓解，却因不忌房事而使病情复发致死，也曾有所见。因此，病后慎养，以防房、劳复和食复，是医嘱中特别重要之事。

伤寒差已后，更发热者，小柴胡汤主之。脉浮者，以汗解之；脉沉实者，以下解之。（410）

【解析】本条为伤寒差后复发热的辨证论治举例。

伤寒初愈，或因劳复，或因食复，或因新感，而又出现发热，其治疗仍要平脉辨证，具体分析，不能一概而论。若脉见浮者，为邪在表，可用汗法；若脉见沉实者，为邪结于里，可用下法；若非表非里，而属少阳枢机不利者，可用小柴胡汤和解之法。

上条所述的病后劳复枳实栀子豉汤证，与本条所论病后复发热，可据情酌用汗、下、和等法，都是针对病后发热而言的。以下两条将介绍病后之寒证。寒热证治对比分析，更突出了辨证论治的精神。

大病差后，从腰已下有水气者，牡蛎泽泻散主之。（411）

牡蛎泽泻散方：

牡蛎熬 泽泻 栝蒌根 蜀漆洗，去脚（赵本作“腥”） 葶苈熬 商陆根熬 海藻洗去咸，已上各等分

上七味，异捣下筛为散，更入臼中治之，白饮和，服方寸匕。小便利，止后服，日三服。

【解析】本条论述大病差后，水邪凝聚腰下的证治。

伤寒或杂病，凡大病差后，见腰以下肿者，为水湿之邪凝聚于下所致，其小便必然不利。因患水邪结聚，故其脉多见沉而有力。治当利小便、逐水邪，方用牡蛎泽泻散。

牡蛎泽泻散用海藻、牡蛎入肝软坚去水；葶苈子泻肺以利水；商陆根逐水之结，与葶苈子相配，则使上中下三焦之水荡然无遗。蜀漆一药，有劫痰破结之效，可开痰水之凝结。本方消痞、软坚、破结、泄水，力量较大，故加天花粉生津保阴，同时天花粉也有活血脉、清伏热之效。临床用本方治疗肝硬化腹水有效，但其利水退肿的作用较十枣汤为弱。十枣汤泻下逐水，二便俱出；本方泻下作用则为缓。尽管如此，对脾肾气虚，气不化水而水湿内留者，仍应慎用。

大病差后，喜唾，久不了了者，胃上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。（412）

【解析】本条论述大病差后，肺脾虚寒，津液不化的证治。

大病差后，中焦虚寒，脾失健运，津液不布，上焦虚寒，肺失宣降，津液凝聚。手足两太阴俱虚，津液不化，聚而为饮，故证见多唾，且长久不愈，即所谓“久不了了”。其治法“当以丸药温之”，用理中丸温中益气为宜。庶脾肺得温，阳气健运，津液得以布化，则喜唾可愈。

《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治》中云：“肺中冷，必眩，多涎唾，甘草干姜汤以温之”，其证治与本条有相似之处，可互相参考补充。

伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐者，竹叶石膏汤主之。（413）

竹叶石膏汤方：

竹叶二把 石膏一斤 半夏半升，洗 人参三两 甘草二两，炙 粳米半升 麦门冬一升，去心

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟，汤成，去米，温服一升，日三服。

【解析】本条论述病后虚热欲吐的证治。

“伤寒解后”，指大病已解，大邪已去。见“虚羸”，即虚弱消瘦，为精血津液不足之象，是言其形体伤；更见“少气”，即呼吸短不足以息，是言其气已伤。今形气两伤，气阴不足，虚热上逆，致胃失和降，故又见“气逆欲吐”。因虚热内扰，或余热未尽，所以还常见到低热、心烦、舌红苔少、脉细数等证，治用竹叶石膏汤清热、养阴、益气、和胃。

竹叶石膏汤用石膏清肺胃气分之热；竹叶隆冬不凋，禀阴气最盛，

善清虚热、治心烦、止呕吐；麦冬补阴气、滋胃阴、养津液、续血脉，使中焦阴液上通于心，心胃阴血津液互相资助；人参、甘草益气生津；粳米益胃气，养胃阴；妙在用半夏一味辛药，活泼中气，和胃降逆。本方现代临床多用于治疗温热病后期，因气阴两伤、虚热内扰、肺胃气逆，而致咳逆、欲呕等证者。其他内外科疾病，只要符合上述病机而见有以上证候者，用之也每获良效。

竹叶石膏汤实为白虎加人参汤加减化裁而成。但竹叶石膏汤用麦冬而不用知母，白虎加人参汤用知母而不用麦冬。因白虎加人参汤证乃阳明气分大热，虽有气阴两伤，但仍以热盛为主，故在治法上以祛邪为要。知母与麦冬虽均为生津养液之品，但知母清热之力胜于麦冬，故当用知母，而不用麦冬。竹叶石膏汤证，乃大病之后，虚羸少气而余热未尽，在治法上以扶正为要。麦冬补液有余而清热不足，故用麦冬而不用知母，以免更伤正气而使病难愈。

病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。（414）

【解析】本条论述大病新差，不可多进饮食的道理。

“病人脉已解”，指病脉已解而转见正常脉象，但在傍晚前后，即日暮时刻微觉烦躁。此乃因大病新差，脾胃之气尚弱，强食多饮，必不能消化。饮食不消，羸弱中焦，故令人发烦。因为这种微烦，产生于人强与谷而不能消，非为食滞，故无须用药治疗，只要减少饮食即可，即所谓“损谷则愈”。

【小结】

《伤寒论》在六经病证之后列出本篇，对病后慎养，防止复发，巩固疗效有着重要临床意义。对大病差后所遗留和发生的寒热虚实种种病证，也作出了辨证论治的示范。

枳实栀子豉汤、理中丸、竹叶石膏汤等，都为临床常用之方，应熟练掌握以广其治。

附：《伤寒论》原文校勘

【伤寒论原文校勘说明】

本校勘以《注解伤寒论》为蓝本，以《脉经》、《千金翼方》（简称《千金翼》）、《金匱玉函经》（简称《玉函》）、《伤寒论》（赵开美的复刻本，简称赵本）、《医统正脉》（简称《医统》）、《伤寒论集成》（简称《集成》）诸书为对校版本，按《注解伤寒论》条文顺序，逐字逐句进行校阅。又《千金要方》（简称《千金》）、《外台秘要》（简称《外台》）、《古本康平伤寒论》（简称《康平》）作为本次校勘参考对校版。本校勘错简、遗漏之处，恐为难免，敬请读者多加指正。

【蓝本及对校书目版本、出版年代】

- （1）《注解伤寒论》人民出版社，1978年6月第一版第五次印刷。
- （2）《脉经》商务印书馆，1959年6月上海第七次印刷。
- （3）《千金翼方》人民出版社，1982年1月第一版第五次印刷。
- （4）《金匱玉函经》人民出版社，1956年1月第一版第三次印刷。
- （5）《伤寒论》（张仲景原著，重庆市中医学会编注）重庆人民出版社，1962年1月第二版第十六次印刷。
- （6）《医统正脉》（《注解伤寒论》）江阴朱文震校刊本。
- （7）《伤寒论集成》（日·山田正珍）人民出版社，1957年6月第一版第一次印刷。

(8) 《古本康平伤寒论》(日·大塚敬节校正)千顷堂书局,1955年5月第一版第四次印刷。

1.《千金翼》、《玉函》无“脉浮”两字,而另有一条为“太阳病,其脉浮”。

2.《千金翼》、《玉函》“汗出”下有“而”字;“脉缓者”句作“其脉缓”;“为中风”句上无“名”字;又另有一条为“太阳中风,发热而恶寒”。

3.《玉函》“脉”字上有“其”字;“俱紧”下无“者”字;“曰伤寒”上无“名”字。《千金翼》无“者”字。《千金翼》、《玉函》、《集成》“名曰”作“名为”。

4.《千金翼》、《玉函》、《集成》“燥”作“躁”。《玉函》“躁烦”上无“若”字;“为传也”作“乃为传”。《千金翼》亦作“乃为传”;“欲吐”作“欲呕”。

5.《千金》、《玉函》本条作“伤寒其二阳证不见,此为不传”。

6.《玉函》“恶寒”下无“者”字。《玉函》、赵本、《集成》等“太阳病……再逆促命期”为一条。

7.《玉函》“身灼热”作“身体灼热”。“名曰风温”句,《玉函》作“为风温”;《千金翼》、《集成》作“名风温”。《玉函》“为病”上有“之”字。“自汗出、身重、多眠睡”作“汗出、体重、多眠”;《医统》“身重”作“身肿”。《玉函》“语言”作“语声”;“若被下者”作“若下之”;“若被火”下无“者”字;“发黄”下无“色”字;“时痙痙”作“时掣纵发作”;“若火熏之”作“复以火熏之”。赵本“痙痙”作“痙痙”。

8.《千金翼》、《玉函》“病”字上有“夫”字;两个“恶寒”上均有“而”字;“无热”均作“不热”。赵本、《集成》在“六日”、“七日”之上均无“者”字。

本条《玉函》列为“太阳篇”第1条。

9.《千金翼》、赵本、《集成》“已”作“以”。“以上自愈者”句,《玉函》作“有当愈者”。“以行其经尽故也”句,《千金翼》、《玉函》均作“其经竟故也”。《玉函》“针”上有“当”字。

10.《千金》、《玉函》“至未上”作“尽未”二字。

11.以上诸本皆同。

12.《玉函》本条作“夫病身大热,反欲得衣者,寒在骨髓,热在皮肤;身大寒,反不欲近衣者,热在骨髓,寒在皮肤也”。赵本在“得”字下无“近”字。

13.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“而阴弱”均作“而阴濡弱”。《脉经》、《千金翼》无“阳浮者”之“阳”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“阴弱者”皆作“濡弱者”。《康平》“阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出。”十二字作旁注。《千金翼》“嗇嗇”作“濇濇”。《脉经》、《玉函》“干呕”下均无“者”字。

桂枝汤方：

《千金翼》、赵本、《集成》均无药性。《千金翼》桂枝、芍药、生姜三药皆作“二两”。《千金翼》、《玉函》无“去皮”二字。《玉函》“擘”作“劈”。《脉经》、《千金翼》、赵本、《集成》“㕮咀”后有“三味”二字。《玉函》“㕮咀”后有“三物”二字；“水七升”上无“以”字。《千金翼》、《玉函》“去滓”下无“适寒”二字；“须臾”上无“服已”二字；“𩚑”均作“饮”；“粥”字上无“稀”字。赵本“漓”作“离”、“小促”下无“役”字；“若汗不出”下无“者”字。《玉函》自“温覆”以下作“温覆令汗出，一时许益佳，若不汗，再服如前；又不汗，后服当小促其间，令半日许，三服尽。病重者，一日一夜服，晬时观之，服一剂尽，病证犹在，当复作服。若汗不出者，服之二三剂，乃解”；而无“禁生冷”以下十五字。《千金翼》亦同，唯有“若汗不出者，乃服至二三剂”句作“至有不汗出，当服三剂乃解”；“一日一夜服”作“一日一夜乃差”；“晬”字上有“当”字；“服一剂尽”作“服一剂汤”；“当复作服”下有“之”字。赵本、《集成》“汗不出”下无“者”字。

14.《脉经》、《千金翼》、《玉函》、赵本“恶风”下均无“者”字。《脉经》下更有“若恶寒”三字，且“桂枝汤主之”作“属桂枝汤证”。

15.《千金翼》、《玉函》“反汗出恶风”句上有“而”字，下无“者”字；“桂枝加葛根汤主之”句作“桂枝汤主之，论云桂枝加葛根汤主之”。《千金翼》“论云”作“本论云，桂枝加葛根汤”。

桂枝加葛根汤方：

《玉函》、《医统》本方中均无“麻黄”。《医统》“右七”作“右六”。《玉函》水“一斗”作“九升”。《医统》“先煮麻黄葛根”句作“先煮

桂枝葛根”。余如桂枝下有“汤”字。赵本、《集成》余如桂枝法后有“将息及禁忌”五字。赵本本条末有林校云：“臣亿等谨按仲景本论，太阳中风自汗用桂枝，伤寒无汗用麻黄，今证云汗出恶风，而方中有麻黄，恐非本意也。第三卷有葛根汤证云，无汗恶风，正与此方同，是合用麻黄也。此云桂枝加葛根汤，恐是桂枝中但加葛根耳”。

16.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“下之”下无“后”字。“气上冲”上《脉经》无“其”字。《脉经》、《千金翼》“气上冲”下均无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》中均无“方用前法”四字。“若不上冲者”句《脉经》、《千金翼》均作“不冲”二字；《玉函》作“不冲者”。“不可与之”句赵本、《集成》作“不得与之”。《康平》“方用前法”句及“若不上冲者，不可与之”句皆作旁注，不列正文。

17.《脉经》“已发汗”作“已发其汗”。《脉经》、《千金翼》无三个“若”字。“仍不解者”句《脉经》、《千金翼》、《玉函》均作“而不解”。“桂枝不中与也”句，《玉函》作“桂枝不复中与也”；《脉经》作“桂枝复不中与也”；《千金翼》作“桂枝汤复不中与也”；《医统》作“桂枝不可与也”；赵本、《集成》作“桂枝不中与之也”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“随证”下均有“而”字。《康平》自“桂枝不中与也”以下十九字作旁注。赵本此条与下条18条并为一條。

18.《千金翼》、《玉函》“桂枝”作“桂枝汤”；“其人”上无“若”字；“汗不出者”作“无汗”。赵本、《集成》“不可与也”作“不可与也”。《千金翼》“常须识此”作“常识此”。

19.《千金翼》没有“若”字。《玉函》首无“若”字，“酒客”下无“病”字；“得汤”作“得之”；“酒”上无“以”字。“得汤”赵本、《集成》作“得之”。

20.《千金翼》、《玉函》“杏子”作“杏仁”。《医统》“杏子佳”作“杏子仁”。《康平》本条与下条并为一條。

21.《千金翼》、《玉函》没有“凡”字和“也”字。《康平》“凡”作“又”。

22.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“汗”字上有“其”字；“漏”字下有“而”字；“屈伸”下无“者”字。“桂枝加附子汤主之”，《脉经》作“属桂枝加附子汤”。

桂枝加附子汤方：

赵本、《集成》有本方。药物、剂量、煎服法均有详细记载。《千金翼》中亦无本方，而但云“桂枝中加附子一枚，炮，即是”。《康平》有“本云桂枝汤，今加附子”九小字为注。

23.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“后”均作“其”。《玉函》“下之”下无“后”字；“脉促”上无“其”字；“胸满”下无“者”字；“去芍药”上有“桂枝”二字，下无“方中”二字。《脉经》、《千金翼》、赵本“微恶寒”作“微寒”。《脉经》“桂枝去芍药汤主之”作“属桂枝去芍药汤”。赵本、《集成》“去芍药方中加附子汤主之”作“桂枝去芍药加附子汤主之”。《脉经》作“属桂枝去芍药加附子汤”。赵本本条自“若”字以下，析为另条。

桂枝去芍药汤方：

赵本、《集成》有桂枝去芍药汤方，药物、剂量、煎服法均详于本书。《康平》“本云桂枝汤，今去芍药”九字作注。

桂枝去芍药加附子汤方：

赵本、《集成》有本方，药物、剂量、煎服法均详于本书。《康平》“本云桂枝汤，今去芍药加附子”十二字作小注。

24.《千金翼》“如疟”下无“状”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“发热”下有“而”字。《千金翼》、《玉函》“热多”下亦有“而”字。“欲自可”《玉函》作“自调”，《脉经》作“续自可”。“一日二三度发”，《玉函》作“日二三发”；《脉经》、《千金翼》作“一日再三发”。《脉经》不可发汗篇无“脉微缓者为欲愈也”句。《千金翼》“脉微缓者”上有“其”字。《千金翼》、《玉函》“为欲愈也”均无“也”字。《玉函》“脉微而恶寒”下无“者”字；《脉经》亦同，并其上有“其”字。《脉经》、《千金翼》“阴阳俱虚”上均有“为”字。“不可更发汗、更下、更吐也”句，《千金翼》、《玉函》皆作“不可复吐下发汗也”。《脉经》作“不可复发汗也”。“反有热”上《玉函》“面”下无“色”字，其下《千金翼》无“色”字。《千金翼》、《玉函》“未欲解也”均作“为未欲解”。

《千金翼》“汗出”上无“小”字。《康平》“小汗”作“少汗”。《千金翼》、《玉函》“汗”上无“小”字；“身必”下均有“当”字。“桂枝麻黄各半

汤”上均无“宜”字，而下有“主之”二字。《康平》自“脉微缓者”起至“未欲解也”为四十小字。

桂枝麻黄各半汤方：

《玉函》无“去皮”、“切”、“去节”、“擘”及“汤浸去皮尖及两仁者”等字，《千金翼》亦无“汤浸”二字。《玉函》“右七味”下有“咬咀”二字。赵本、《集成》“六合”后有“本云、桂枝汤三合，麻黄汤三合，并为六合，顿服将息如上法”。《玉函》“温服六合”下有“本方二汤各三合，并为六合，顿服，今裁为一方”。《千金翼》无“将息如上法”五字。《康平》“本云”至“顿服”十八字作小注。赵本在“将息如上法”后有林校小字作“臣亿等谨按桂枝汤方，桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。麻黄汤方，麻黄三两，桂枝二两，甘草一两，杏仁七十个，今以算法约之，二汤各取三分之一，即得桂枝一两十六铢，芍药、生姜、甘草各一两，大枣四枚，杏仁二十三个零三分枚之一，收之得二十四个，合方，详此方，乃三分之一，非各半也，宜云合半汤”。

25.《脉经》、《千金翼》“反烦”上有“而”字。《千金翼》、《玉函》“先刺”上有“当”字。《脉经》有“法当”二字。《康平》本“风池”“风府”，四字作旁注。《玉函》“则愈”作“即愈”。

26.“脉洪大者”《脉经》、《玉函》皆作“若脉但洪大”；《千金翼》作“若脉洪大”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》均无“如前法”三字；并于“形如疟”上均有“其”字，唯《千金翼》更无“若”字。赵本“如疟”作“似疟”。《玉函》、赵本、《集成》“日再发”上有“一”字。《脉经》“再发者”作“再三发”。《千金翼》、《玉函》“再发”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“必解”均作“便解”。《脉经》“宜桂枝二麻黄一汤”作“属桂枝二麻黄一汤”。

桂枝二麻黄一汤方：

《千金翼》、《玉函》“桂枝”下无“去皮”，“麻黄”下无“去节”。《玉函》“生姜”下无“切”，“大枣”下无“擘”，“甘草”下无“炙”，“杏仁”无“去皮尖”。《千金翼》“杏仁”“去皮尖”下有“两仁者”三字。“水五

升”作“水七升”，并“升”字下无“先”字。赵本、《集成》“日再”下有“服”字。“本云”以下有“桂枝汤二分，麻黄汤一分，合为二升，分再服，今合为一方，将息如前法”。《玉函》“本云”作“本方”。《千金翼》“分再服”作“分二服”。《千金翼》、《玉函》均无“将息如前法”五字。《康平》“桂枝”作“一两十六铢”，“生姜”亦作“一两十六铢”，“杏仁十六个”作“十六铢”。自“本云”以下至“今合为方”作小注。并“合为一方”作“合为方”。“将息如前法”作“将息为上法”。赵本在“将息如前法”后有林校小字，作“臣亿等谨按桂枝汤方，桂枝芍药生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。麻黄汤方，麻黄三两，桂枝二两，甘草一两，杏仁七十个，今以算法约之，桂枝汤取十二分之五，即得桂枝、芍药、生姜各一两六铢，甘草二十铢，大枣五枚。麻黄汤取九分之二，即得麻黄十六铢，桂枝十铢三分铢之二，收之得十一铢，甘草五铢三分铢之一，收之得六铢，杏仁十五个九分枚之四，收之得十六个。二汤所取相合，即共得桂枝一两十七铢，麻黄十六铢，生姜芍药各一两六铢，甘草一两二铢，大枣五枚，杏仁十六个，合方”。

27.《脉经》“大汗出”下无“后”字。《脉经》、《玉函》“脉洪大”上均有“若”字。《脉经》“洪大”下无“者”字，并“白虎加人参汤主之”作“属白虎汤”。

白虎加人参汤方，《康平》不载此方。

28.《玉函》“发热”下有“而”字。《脉经》、《千金翼》“脉微弱”下无“者”字，“此无阳也”作“则无阳也”。《脉经》、《玉函》“不可更汗”作“不可复发其汗”。《千金翼》、赵本、《医统》、《集成》“不可更汗”作“不可发汗”；《脉经》“不可更汗下”无“桂枝二越婢一汤”句，而接以“咽干燥者，不可发汗”句。《千金翼》“桂枝”上无“宜”字。《康平》“此无阳也”句作“脉微弱者”句之旁注。“不可发汗”作“不可大发汗”。并本条与下条为一条。《玉函》尾无“方”字。

桂枝二越婢一汤方：

《千金翼》、《玉函》“生姜一两三钱切”皆作“生姜一两三铢切”。《玉函》“桂枝”下无“去皮”，“大枣”无“擘”，“生姜”无“切”，“石膏”无“碎绵裹”等字，《千金翼》“桂枝”下亦无“去皮”。赵本“麻黄”下无“去节”；“甘草”下有“炙”。赵本、《集成》“右七味”下无“㕮咀”二字。《千金翼》“煮麻黄”上有“先”字；《玉函》“五升水”作“水五

升”，“去滓”作“去渣”。赵本、《集成》“本方”作“本云”。《千金翼》“越婢汤，桂枝”下无“汤”字。《玉函》、赵本、《集成》“合”字下有“之”字，又“桂枝二越婢一”作“桂枝汤二分，越婢汤一分”。《玉函》煎服法中“婢”皆作“脾”。《千金翼》无最后一句“越婢一”。赵本在“越婢汤一分”后有“臣亿等谨按桂枝汤方：桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。越婢汤方，麻黄二两，生姜三两，甘草二两，石膏半斤，大枣十五枚。今以算法约之，桂枝汤取四分之一，即得桂枝、芍药、生姜各十八铢，甘草十二铢，大枣三枚。越婢汤取八分之一，即得麻黄十八铢，生姜九铢，甘草六铢，石膏二十四铢，大枣一枚八分之七，弃之，二汤所取相合，即共得桂枝、芍药、甘草、麻黄各十八铢，生姜一两三铢，石膏二十四铢，大枣四枚，合方。旧云，桂枝三，今取四分之一，即当云桂枝二也。越婢汤方，见仲景杂方中。《外台秘要》：一云起脾汤。”

29.《脉经》、《千金翼》无“或”字、“仍”字。《千金翼》“头项”作“颈项”。《玉函》“心下满”下有“而”字。《脉经》、《千金翼》“小便不利”下无“者”字。《玉函》、赵本、《医统》“桂枝”下无“汤”字。《脉经》“桂枝去桂加茯苓白术汤主之”作“属桂枝去桂加茯苓白术汤”。

桂枝去桂加茯苓白术汤方：

赵本、《集成》有本方，药物、剂量、煎服法均有详载。《康平》“本云桂枝汤，今去桂枝加茯苓白术”作小字注。

30.《玉函》“自汗”下无“出”字；“小便数”与“心烦”之间有“颇微恶寒，论曰”六字。《脉经》“心烦”作“颇复”并下有小注云“仲景颇复字作心烦”八字。《千金翼》亦同，只少小注。《玉函》“脚挛急”上有“两”字，《脉经》、《千金翼》共有“而”字。赵本、《集成》“反与桂枝”下皆无“汤”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》均无“此误也”三字。《康平》“欲攻其表，此误也”七字作小注。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“咽”下皆无“中”字。《康平》“燥”上无“烦”字。《玉函》、赵本、《集成》“燥”作“躁”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“呕逆”下皆无“者”字，又“作甘草干姜汤”上皆有“当”字，并下无“与之”二字，又“厥愈足温”上皆无“若”字，并下无“者”字。《康平》“以复其阳”四字作旁注。《脉经》、《医统》“伸”作“仲”。《康平》无“其脚即伸”四字。《脉经》、《千金翼》“胃气不和”上之“若”作“而”。《千金翼》无“谗语者”三字。《脉经》、《玉函》“谗语”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》“少与”作“可与”；“调胃承气汤”无“调胃”二字。《脉经》“若重发汗”作“重发其汗”。《千金翼》“重发汗”上无“若”字。《康平》“少与”作“小与”；“复加烧针”下无“者”字，而有“得之者”一句；“四逆汤”作“回逆汤”。《脉经》作“属四逆汤”。

甘草干姜汤方：

《玉函》甘草作“二两”，“右”下有“二味”二字。赵本、《集成》干姜下无“炮”字，右**咬**咀下无“**咬**咀”二字、有“二味”。“煮取一升五合”，《千金翼》作“煮取一升”。《集成》作“煮取二升五合”。

芍药甘草汤方：

《千金翼》、《玉函》“芍药”上无“白”字。《玉函》“一升半”作“一升五合”；“再服”下无“之”字。《集成》“甘草”下无“炙”字。赵本、《集成》“右二味”下无“**咬咀**”二字；“一升半”均作“一升五合”；“再服”下皆无“之”字。《康平》不载此方。

调胃承气汤方：

《玉函》“大黄”下无“去皮”二字。赵本、《集成》“酒浸”作“酒洗”。《外台》“甘草”作“三两”。“芒硝半斤”，《千金翼》“芒硝”作“半两”；《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“芒硝”作“半升”。赵本、《集成》“右”下无“**咬咀**”二字。赵本、《医统》、《集成》“温服”下有“之”字。《康平》此处不载此方，《千金翼》亦同。

四逆汤方：

《玉函》“附子”下作“一枚生去皮破”，“三味”下无“**咬咀**”二字。《千金翼》“生”字下无“用”字。赵本、《集成》“右三味”下也均无“**咬咀**”二字。《康平》此处不载本方。

31.《玉函》“师”字下无“曰”字；“知此”作“知之”；两“为”字上的“则”均作“即”字。赵本、《集成》两“为”字上均无“则”字。《玉函》“病证”作“其形”。赵本、《集成》“病证”作“病形”。《玉函》“参”作“於”。《玉函》、赵本、《集成》“燥”作“躁”。《玉函》无“重与”之“重”字；“以承气汤”作“与承气汤”；“止其”上无“则”字；“病可愈”上有“其”字。《康平》第一个“咽中干”下有“燥”字。

32.《玉函》、《集成》“恶风”下有“者”字。《脉经》“葛根汤主之”作“属葛根汤”。

葛根汤方：

《玉函》“麻黄”下无“三两”二字；“生姜”下有“各”字；“桂枝”下无“二两、去皮”四字；“芍药”下无“二两、切”三字；“甘草”下

有“各”字；“大枣”下无“擘”字。赵本“桂”下有“枝”字。《集成》“桂枝”作“三两”。赵本、《集成》“芍药”下无“切”字；“右七味”下无“咬咀”二字。《千金翼》“煮”字上无“先”字。赵本、《集成》“去沫”作“去白沫”。《玉函》“去”下有“上”字；“煮取三升”作“煮取一升”。《千金翼》自“温服一升”以降廿四字，作“分温三服，不须与粥，取微汗”。

《玉函》自“复取微似汗”作“取汗”，无“余如桂枝法将息及禁忌”十字。

《康平》“似汗”上无“微”字。赵本、《集成》在“覆取微似汗”下无“不须啜粥”四字，而最后有“诸汤皆倣此”五字。《康平》有“诸汤药皆倣之”六字作小注。

33.《千金翼》、《玉函》“合病”下无“者”字。《千金翼》“必自下利”作“而自利”。《玉函》“必自”下无“下”字。《千金翼》最后有“一云用后葛根黄芩黄连汤”。《脉经》“合病”下亦无“者”字；“必自下利”句作“而自利不呕者”；“葛根汤主之”作“属葛根汤证”。《玉函》本条与下条并为一条。

34.《千金翼》、《玉函》均无第一句。《脉经》、《千金翼》“但呕”下无“者”字。《脉经》“葛根加半夏汤主之”作“属葛根加半夏汤”。

葛根加半夏汤方：

《玉函》“麻黄”下无“三两、去节、汤泡去黄汁焙干秤”十二字；“生姜”下无“三两切”三字；“桂枝”下无“二两去皮”；“芍药”下无“二两”；“甘草”下有“各”字，无“炙”字；“半夏半斤”作“半夏半升”；“大枣”下无“擘”字。赵本、《集成》“生姜”作“二两”。《玉函》“白沫”作“上沫”；“覆取微似汗”作“取汗”二字。《千金翼》不载本方，但云“葛根汤中加半夏半升洗即是”。

35.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“遂”字在“利”字上；“脉”字上有“其”字。《千金翼》、《玉函》“促”字下无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“解”字下均无“也”字；“汗出”下亦均无“者”字。《千金翼》“葛根黄芩黄连汤主之”句作“宜葛根黄芩黄连汤方”。《脉经》作“属葛根黄芩黄连汤”。赵本最后有“促一作纵”四字小注。《康平》“脉促者，表不解也”七字作旁注。

葛根黄芩黄连汤方：

赵本、《集成》“黄芩”作“三两”。《玉函》“黄芩”下无“二两”；“黄连”下有“各”字；“右四味”下有“㕮咀”二字；“分温再服”作“温分服”。

36.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“身疼”皆作“身体疼”。《千金翼》“骨节疼”下无“痛”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“而喘”下均无“者”字。《脉经》“麻黄汤主之”作“属麻黄汤证”。

麻黄汤方：

《玉函》“麻黄”下无“去节”二字。《医统》“桂枝”作“三两”。《千金翼》、《玉函》“桂枝”下无“去皮”。《玉函》“杏仁”作“七十枚”，无“汤去皮尖”四字；《千金翼》亦作“七十枚”，“去皮尖”下有“两仁者”三字；赵本、《集成》“杏仁，汤去皮尖”上无“汤”字。《玉函》“右四味”下有“㕮咀”二字。《集成》“以水九升”作“以水五升”。《千金翼》“煮”字上无“先”字。《玉函》“覆取微似汗”作“温覆出汗”。《千金翼》、《玉函》“全如桂枝法”下无“将息”二字。

37.《脉经》、《千金翼》“胸满”下无“者”字；“不可下”下有“也”字。赵本、《集成》“宜麻黄汤”下无“主之”二字。《脉经》作“属麻黄汤证”。

38.《千金翼》、《玉函》“病”字上无“太阳”二字；“脉浮细”上有“其”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“嗜卧”上均无“而”字，其下均无“者”字；“外已解也”句均作“此为外解”；“胸满胁痛”下均无“者”字。《脉经》、《玉函》“脉但浮”句无“但”字。《千金翼》“脉但”二字皆无；“与麻黄汤”句作“麻黄汤主之”，《脉经》作“属麻黄汤证”。赵本本条下首见小柴胡汤方。

39.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“身疼痛”皆作“身体疼痛”。《脉经》、《玉函》“烦躁”下无“者”字，而多“头痛”二字。《千金翼》“而烦”下无“躁者”二字。《脉经》“大青龙汤主之”作“属大青龙汤”；“脉微弱”上无“若”字。《脉经》、《玉函》“恶风”下无“者”字。《玉函》“服”字下无“之”字。赵本、《集成》“不可服”下有“之”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“厥”字下皆无“逆”字。《医统》“此为逆也”下有“大青龙汤主之”六字。《康平》“此为逆也”四字作旁注。

大青龙汤方：

《玉函》“麻黄”下无“去节”二字。《千金翼》、《玉函》“桂枝”下无“去皮”二字。《玉函》、赵本、《集成》“杏仁四十个”作“四十枚”。《千金翼》“去皮尖”下有“两仁者”三字。《玉函》“杏人”作“杏仁”下无“去皮尖”三字，“生姜”下无“切”字。赵本、《集成》“大枣”作“十枚”。《玉函》“大枣”下无“擘”字。《玉函》、《康平》“石膏”下“鸡子”上无“如”字。《千金翼》、《玉函》“碎”字下均有“绵裹”二字。《玉函》“取微似汗”作“覆令汗出”；“汗出多者”作“多者”，无“汗出”二字。《千金翼》、赵本、《医统》“扑之”均作“粉之”；《康平》“汗出多者，温粉扑之”八字作小注。《千金翼》“停后服”作“勿再服”。《玉函》、赵本、《集成》有“若复服”三字。《千金翼》“汗多”作“汗出多”。赵本“遂”字下有“一作逆”三字小注。《千金翼》“躁”上无“烦”字。《千金翼》、《玉函》“不得眠”下无“也”字。《康平》自“若复服”以下十七字作小注。

40.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“身不疼”上均有“其”字。《千金翼》、《玉函》“大青龙汤发之”下皆有“可与”二字。《康平》“发之”作“主之”；“无少阴证者”五字作旁注。

41.《千金翼》、《玉函》“干呕发热而咳”句皆作“欬而发热”。《康平》“小便不利”上无“或”字。《脉经》、《玉函》、《康平》“少腹满”皆作“小腹满”。《脉经》、《玉函》“或喘者”作“或微喘”。《脉经》“小青龙汤主之”作“属小青龙汤”。

小青龙汤方：

《玉函》“麻黄”下无“去节”二字；“桂枝”下无“去皮”二字；“甘草”下无“炙”字；“五味子”下有“碎”字；“半夏”下无“汤洗”二字；八味药均为“半升”。《千金翼》“桂枝”下亦无“去皮”二字。赵本、《集成》“半夏”下之“汤洗”作“洗”。赵本、《集成》“若渴者”作“渴者”，《千金翼》作“渴则”；赵本、《集成》“渴”字下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“微利”上无“若”字；《玉函》、赵本、《集成》“微利”下无“者”字。《千金翼》“尧花”下无“如”字；“鸡子”上有“一”字；《千金翼》“鸡子”下有“大”字；赵本、《医统》“鸡子”下无“大”字。《千金翼》、《玉函》“噎者”上无“若”字；“小便不利”上亦无“若”字。《玉函》、赵本、《集成》“少腹满”下有“者”字。《千金翼》、《玉

函》“喘”上无“若”字。赵本、《集成》“若喘”下无“者”字。《玉函》“杏人”作“杏仁”其下无“去皮尖”三字。《千金翼》“杏仁半升去皮”无“尖”字。《玉函》最后有“薏花不治利，麻黄定喘，今反之者，疑非仲景意”十八字。赵本、《集成》“且薏花不治利”以下有“麻黄主喘。今此语反之，疑非仲景意”。赵本林校“臣亿等谨按小青龙汤，大要治水。又按本草，薏花下十二水，若水去，利则止也。又按《千金》，形肿者，应内麻黄，乃内杏仁者，以麻黄发其阳故也。以此证之，岂非仲景意也。”

42.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“已”字下有“而”字。《脉经》“解”字上有“为”字，下无“也”字。《千金翼》、《玉函》“欲解”上有“为”字，下无“也”字。《康平》自“服汤已渴者”以下十一字作旁注。《脉经》“小青龙汤主之”作“属小青龙汤”。

43.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“脉浮弱”上均有“其”字，下均无“者”字。《玉函》“汤”下有“主之”二字。

44.《千金翼》在《太阳病用麻黄汤法第二》中复有本条曰“太阳病，下之微喘者，外未解故也，宜麻黄汤。一云桂枝汤”。《脉经》“桂枝加厚朴杏人汤主之”作“属桂枝加厚朴杏子汤证”。《玉函》“杏人”作“杏仁”。

桂枝加厚朴杏子汤方：

《集成》厚朴“二两”作“三两”。

45.《脉经》、《千金翼》“外证”上有“有”字。《脉经》、《千金翼》、赵本、《康平》“未解”下均无“者”字。《脉经》、《玉函》、《康平》“不可下”下均无“也”字。《千金翼》“不可下也”作“不可下之”。《脉经》无“欲解外者宜桂枝汤”八字。《千金翼》“解外”二字上无“欲”字，下无“者”字；《玉函》亦无“欲”字。赵本、《集成》“桂枝汤”下无“主之”二字而作“宜桂枝汤”。《康平》“下之为逆”四字作旁注。

46.《脉经》“先发”下有“其”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“而复下之”作“而下之”；“脉浮”上共有“其”字。《千金翼》、《玉函》“脉浮”下无“者”字。《脉经》、赵本、《集成》“故知在外”作“故在外”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“当须解外”均作“当解其外”。赵本、《集成》“桂枝汤”下无“主之”二字，作“宜桂枝汤”。《脉经》“宜桂枝汤主之”作“属桂枝汤”。

47.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“发热”上均有“而”字；“身疼痛”上均有“其”字；“表证”又均作“表候”。《千金翼》、《玉函》“表”字上有“其”字。《脉经》“仍在”作“续在”；“服药已微除”作“服汤微除”。

《千金翼》“服药”下无“已”字。《康平》“此当发其汗”以下十字作小注，并“除”下有“也”字。《脉经》“发烦”上无“其人”二字。《千金翼》“剧者”上有“增”字。《康平》“衄乃解”作“衄乃愈”，并此三字作为“所以然者”句之旁注。《千金翼》“麻黄汤主之”句作“宜麻黄汤”。《脉经》作“属麻黄汤证”。

48.《玉函》“身无汗”上有“其”字。

49.《脉经》“汗先出”下有“复”字；“若太阳”下无“病”字；“不罢”下无“者”字，《玉函》“不罢”下无“者”字。《康平》无“若”字，并自“太阳病证不罢者”以下至“为逆”为小注，又“之为逆”上无“下”字。《脉经》、《玉函》“如此”下皆有“者”字，“小发”下皆有“其”字。《康平》“小发汗”上有“以”字。《玉函》“怫郁在表”作“怫郁不得越”，并无“若发汗不彻，不足言，阳气怫郁不得越”等十五字。《脉经》“不彻”作“不大彻”。《康平》“在表当解之，薰之”，七字作旁注，又自“若发汗不彻”至“阳气怫郁”共十一字作小注，其中在“不足”下无“言”字。《脉经》、《玉函》“当汗”下有“而”字。《康平》自“当汗不汗”至“按之不可得”二十四字作小注，其中“不知痛处”上有○印，“四肢”上无“在”字，而亦有○印。《脉经》“以汗出不彻故也”作“汗出而不彻故也”。《康平》此句“以汗出不彻故也”作旁注。《脉经》、《玉函》“更发汗则愈”皆作“更发其汗即愈”。《脉经》“何以知汗出不彻”作“何以知其汗不彻”。“以脉涩故知也”句《玉函》作“以脉涩故知之”；《脉经》作“脉涩故以知也”。《康平》“何以知汗出不彻，以脉涩故知也”十三字作小注，并其下有“若阙文”三字。

50.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“脉浮数”下皆无“者”字。《康平》“汗出而愈”作“汗出而解”。《脉经》、《千金翼》“若下之”作“而下之”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“身重”统作“身体重”，并《脉经》、《千金翼》“身”字上复共有“则”字。《脉经》“心悸”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》“不可发汗”作“不可发其汗”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“乃解”皆作“而解”。《脉经》“尺中脉微”作“尺中脉浮”；“津液”下无“自”字。《脉经》、《玉函》“便自汗出愈”作“即自汗出愈”。《千金翼》无“便”字。

51.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“脉浮紧者”，皆作“脉浮而紧”。“身疼痛”，《玉函》作“身疼头痛”；《脉经》、《千金翼》作“身体疼痛”。《脉经》、《千金翼》“宜”作“当”；“汗解”下同无“之”字。

《脉经》、《千金翼》、《玉函》“尺中迟”皆作“尺中脉迟”。“不可发汗”句，《脉经》、《玉函》作“不可发其汗”；《千金翼》作“忌发其汗”。“何以知之然”句《玉函》作“何以故”；赵本、《集成》作“何以知然”。《脉经》、《玉函》“以荣气不足”皆作“此为营气不足”。“血少故也”句，《千金翼》、《玉函》作“血气微少故也”；《脉经》作“血微少故也”。

52.《脉经》“可发汗”作“可发其汗”；“麻黄汤”作“桂枝汤”。《玉函》“麻黄汤”下有“一云桂枝汤”五字。赵本最末有“法用桂枝汤”五字。《康平》本条与下条合为一条。

53.《千金翼》“可发汗”作“可发其汗”。

54.赵本、《集成》“和谐”作“谐和”。《玉函》本条作“病常自汗出者，此为营气和，卫气不和故也，营行脉中，为阴主内，卫行脉外，为阳主外，复发其汗，卫和则愈，宜桂枝汤”。《脉经》同，但“自汗出”下无“者”字；“卫气不和故也”句作“荣气和而外不解，此卫不和也”；“营”作“荣”。《千金翼》亦同，只“自汗出”下亦无“者”字；又无“为阴主内”，“为阳主外”二句；“营”亦作“荣”。《脉经》“宜桂枝汤”作“属桂枝汤证”。

55.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“不愈”下皆无“者”字。《玉函》“则愈”作“即愈”。《千金翼》无“则”字。《玉函》、赵本、《集成》“桂枝汤”下无“主之”二字，作“宜桂枝汤”。《脉经》“宜桂枝汤主之”作“属桂枝汤证”。

56.《脉经》“伤寒”下有“病”字。《脉经》、《千金翼》“汗”字上有“其”字。《脉经》“因致衄者”句作“因衄”二字。《康平》“致衄”作“到衄”。《千金翼》“衄”字下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“麻黄汤主之”作“宜麻黄汤”。《脉经》作“属麻黄汤证”。

57.《康平》“有热”作“在热”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“有热”下皆无“者”字。《玉函》“与承气汤”作“未可与承气汤”；“小便清者”，作“小便反清”。《脉经》、《千金翼》“小便清者”，同作“大便反青”。《脉经》于此处有“一作小便清”五字小注，赵本此处有“一云大便清”五小字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“知”皆作“此为”。

《玉函》“仍”作“而”。《脉经》、《千金翼》“仍”作“故”。《千金翼》、《玉函》“当须发汗”作“当发其汗”；“头痛”上复皆无“若”字。《脉经》“宜桂枝汤”作“属桂枝汤证”。

58.《玉函》、赵本、《集成》“解”字上有“已”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“脉浮数”上同有“其”字，下无“者”字。“可更发汗”句

《玉函》作“可与复发汗”；《脉经》、《千金翼》作“可复发其汗”。
《千金翼》“宜”下有“服”字。《玉函》、赵本、《集成》“汤”下无“主之”二字。《脉经》“宜桂枝汤主之”作“属桂枝汤”。

59.《玉函》“津液”上有“血无”二字。赵本、《集成》“亡津液”上有“若亡血”三字。《脉经》、《千金翼》“亡津液”作“无津液”。《康平》“亡津液”下有“如此者”三字。《脉经》、《千金翼》“阴阳”上共有“而”字。《康平》“者”作“则”。

60.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“复”上无“之”字；“发汗”上无“复”字；“小便不利”上有“其人”二字，下无“者”字；“亡津液”上有“此”字，下无“故也”二字。《脉经》、《千金翼》“治”下无“之”字。
《脉经》、《千金翼》、《玉函》“得”作“其”。《康平》“亡津”下无“液故也”三字；并“亡津”二字为“复发汗”之旁注。

61.《脉经》、《千金翼》“下之后”作“下以后”。“复发汗”句《千金翼》、《玉函》作“发其汗”，《脉经》作“复发其汗”。《脉经》、《千金翼》“脉微细”上有“又其”二字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“内外”上无“以”字。

62.《脉经》、《千金翼》“下之后”作“下以后”。“复发汗”句《玉函》作“复发其汗”，《脉经》、《千金翼》作“复发其汗者”。《康平》无“复”字。《脉经》、《千金翼》“昼”字上有“则”字。《康平》“躁”作“燥”。《脉经》、《千金翼》“眠”上无“得”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“无表证”上同有“而”字。《脉经》、《千金翼》“脉”字上有“其”字；“大热”下无“者”字。《千金翼》“干姜附子汤主之”作“属附子干姜汤”。《脉经》作“属干姜附子汤”。

干姜附子汤方：

《玉函》“附子一枚”下无“生用去皮破八片”七字。《千金翼》无“用”字。赵本、《集成》“破”作“切”。《玉函》“煮”下无“取”字；又无“去滓”二字；“顿服”下有“之”字，《千金翼》“顿服”下有“即安”二字。《康平》“生”下亦无“用”字。

63.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“身”下均有“体”字；“脉”上均有“其”字；“迟”下均无“者”字；“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤”均作“桂枝加芍药生姜人参汤”，《脉经》作“属桂枝加芍药生姜人参汤”。

桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方：

《玉函》方名作“桂枝加芍药生姜人参汤方”，并有细载。赵本、《集成》有“桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方”，药物、剂量、煎服法均有详细记载。

64.《千金翼》“发汗”下有“以”字。《康平》“不可”上有“喘家”二字。《千金翼》“不可”下无“更”字。《脉经》、《千金翼》“与”字上无“可”字。《脉经》“可与”作“可以”。《脉经》、《玉函》“杏仁”作“杏子”。《千金翼》“甘草石膏”作“石膏甘草”。赵本、《集成》“汤”下无“主之”二字。

麻黄杏仁甘草石膏汤方：

《玉函》“麻黄”下无“去节”二字；“杏仁”作“杏子”；“个”作“枚”，无“去皮尖”三字；甘草“二两”作“一两”。《千金翼》“个”亦作“枚”；“石膏”下无“绵裹”二字。《康平》“杏仁去皮”下无“尖”字。赵本、《康平》“煮麻黄”上无“先”字。《千金翼》“减二升”作“一二沸”；“煮取二升”作“煮取三升”。《玉函》、《医统》、《康平》无“本云黄耳杯”五字。《千金翼》“杯”作“杯”。

汪琥云：“黄耳杯”想系置水器也。

65.《脉经》“发汗过多”下有“以后”二字，《千金翼》亦有“以后”二字。《脉经》、《千金翼》“欲得按”上同有“而”字；其下“者”字同作“之”字。《脉经》“桂枝甘草汤主之”作“属桂枝甘草汤”。

桂枝甘草汤方：

《千金翼》、《玉函》“桂枝”下同无“去皮”二字。《千金翼》“顿服”下有“即愈”二字。

66.《千金翼》“脐”作“齐”。《脉经》、《千金翼》“悸”下同无“者”字。《脉经》、《玉函》“奔”作“贲”。《脉经》“茯苓桂枝甘草大枣汤主之”作“属茯苓桂枝甘草大枣汤”。

茯苓桂枝甘草大枣汤方：

《千金翼》、《玉函》“桂枝”下无“去皮”二字。《玉函》“大枣”下无“擘”字。《千金翼》“水”字上无“甘~~爛~~”二字。《玉函》、《医统》“~~爛~~”作“澜”。《玉函》“日三”下无“服”字。《千金翼》、《玉函》无“作甘~~爛~~水法”以下三十一字。《康平》“珠子”上无“有”字。

67.《脉经》、《玉函》、《千金翼》“腹胀满”下均无“者”字。《千金翼》、赵本、《康平》“厚朴生姜甘草半夏人参汤”作“厚朴生姜半夏甘草人参汤”。

厚朴生姜甘草半夏人参汤方：

《玉函》“厚朴”下无“半斤炙去皮”五字。《康平》“厚朴”下无“炙”字。《千金翼》“厚朴”下无“去皮”二字。《玉函》“生姜”下无“半斤切”三字。赵本、《医统》、《集成》半夏“半斤”作“半升”。《玉函》、赵本、《康平》“甘草”下无“炙”字。《玉函》“右五味”下有“~~咬~~咀”二字。

68.《玉函》“若吐、若下后”句作“若吐若下若发汗后”；《脉经》作“吐下发汗后”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》两个“则”字均作“即”字；“脉”字上均有“其”字。《脉经》、《千金翼》“振振摇”作“振摇”，《脉经》、《玉函》、《千金翼》“摇”字下均无“者”字。《脉经》“茯苓桂枝白术甘草汤主之”作“属茯苓桂枝术甘草汤”。《康平》本条与下69、70、71（赵本为68、69、70）三条，合为一条。

茯苓桂枝白术甘草汤方：

《玉函》“桂枝”下无“三两去皮”四字；“白术”下有“各”字，并作“三两”；“甘草”下无“炙”字。《千金翼》“桂枝”下无“去皮”二字。《玉函》无“去滓”二字；“分温三服”下有“小便即利”四字。《康平》“茯苓桂枝白术甘草汤”作“茯苓桂枝甘草汤”。

69.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“发汗病不解”作“发其汗不

解”；“反”字上有“而”字。《脉经》“芍药甘草附子汤主之”作“属芍药甘草附子汤”。《脉经》、《玉函》本条与第71条并为一条。《康平》“虚故也”三字作旁注。

芍药甘草附子汤方：

《玉函》“芍药”“甘草”作“各一两”；“甘草”下无“炙”字，“附子”下无“去皮破八片”五字；“以上三味”作“右三味”，下有“**咬**咀”二字。赵本、《集成》“以上”作“右”。《千金翼》、《玉函》“以水五升”作“以水三升”。“一升五合”《玉函》作“一升三合”，《千金翼》作“一升二合”。《玉函》、赵本、《集成》有“三服”之“三”字。《千金翼》、《玉函》、《康平》皆无“疑非仲景意”五字。赵本“意”作“方”。

70.《玉函》“下”下无“之”字，“躁”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》“若下之病仍不解烦躁者”句作“吐下以后不解烦躁”。《脉经》“茯苓四逆主之”作“属茯苓四逆汤”。《康平》“躁”作“燥”，“茯苓四逆汤”作“茯苓回逆汤”。

茯苓四逆汤方：

《玉函》、赵本、《集成》茯苓“六两”作“四两”。《玉函》“附子”下无“用去皮破八片”六字。《千金翼》“去皮”上无“用”字。《康平》干姜“一两半”作“一两”。《玉函》“右五味”下有“**咬**咀”二字；“煮取三升”作“煮取一升二合”。《千金翼》作“煮取二升”。《玉函》“温服七合，日三服”作“分温再服”。赵本、《集成》“日三服”作“日二服”。《康平》“茯苓四逆”作“茯苓回逆”。

71.《脉经》、《玉函》本条与69条合为一条。《千金翼》虽另析一条，但承69条而言，故三书均无“发汗后，恶寒者，虚故也”句。《脉经》、《千金翼》“胃气”上有“其”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“与调胃承气汤”均作“宜小承气汤”。《千金翼》最后有小注云：“一云调胃承气汤”。赵本最后亦有“玉函云与小承气汤”八小字。《康平》于本条后附有调胃承气汤方。

72.《脉经》“发汗”下无“后”字。《脉经》、《千金翼》“大汗出”上均有“若”字。《脉经》“胃中干”作“胃中燥”。《千金翼》、《康平》“烦躁”均作“燥烦”。《脉经》“不得眠”上无“躁”字。“欲得饮水者”句，《脉经》、《千金翼》、《玉函》作“其人欲饮水”。《脉经》、《千金

翼》、《玉函》三书“少少与饮之”皆作“当稍饮之”。《脉经》、《玉函》“胃气”作“胃中”。赵本、《集成》“五苓散主之”上均无“与”字。《脉经》、《千金翼》无“若脉浮”以下十七字。赵本于本条末有“即猪苓散是”五小字。

五苓散方：

《玉函》“猪苓”、“桂枝”下皆无“去皮”二字；“泽泻”作“一两六铢”而无“半”字；“桂”字下有“枝”字；“右五味”下“为末”二字作“捣为散”，《千金翼》作“各为散，更于臼中治之”。赵本、《集成》“暖水”作“煖水”；“汗出愈”后有“如法将息”四字。《康平》本方在73条后。

73.《千金翼》“发汗”下无“已”字。《玉函》“发汗已”作“发汗后”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“数”字上均有“而”字。“烦渴者”句《脉经》作“复烦渴者”，《千金翼》作“复烦者”。《脉经》“五苓散主之”作“属五苓散”。

74.《脉经》两“渴”字下均无“者”字；“五苓散主之”句作“属五苓散证”；“茯苓甘草汤主之”作“属茯苓甘草汤”。《康平》“不渴者”作“小渴者”。

茯苓甘草汤方：

《玉函》茯苓作“三两”。《集成》甘草作“一两”。《千金翼》、《玉函》“桂枝”下无“去皮”二字；“生姜”下无“切”字。

75.“则吐”《玉函》作“即吐”；《千金翼》作“而”；《康平》作“口”。《千金翼》、《玉函》“名曰”作“此为”；“吐”字下均无“者”字。《康平》“有表里证”句与“名曰水逆”句均作旁注。

76.《脉经》、《玉函》、《康平》“手叉”皆作“叉手”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“而不欬”作“而不即欬者”。《康平》无“耳”字，只印有口印。《脉经》、《千金翼》“两耳聋无闻”作“两耳无所闻也”。《康平》“以重”作“重以”。《脉经》、《千金翼》“重发”上均无“以”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“汗”字上均有“其”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》、《康平》“虚故如此”均作“虚故

也”。赵本本条与77条（赵本为75条）合为一条。

77.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“多”字下均有“者”字。赵本本条与上条合为一条。

78.《千金翼》、《玉函》无“若更……”以下九字，《脉经》“若更发汗”作“若更发其汗”，赵本本条与79条合为一条（赵本为76条）。《康平》“为逆”二字作旁注。

79.《脉经》“发汗”上有“伤寒”二字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“剧”者上无“若”字；“反复”上无“必”字。《脉经》“梔子豉汤主之”作“属梔子汤”。

梔子豉汤方：

《千金翼》“梔子豉汤”作“梔子汤”。赵本、《集成》梔子下“枚”作“箇”。《千金翼》“得”作“取”；“分为二服”作“分再服”。《玉函》“分”下无“为”字。《千金翼》、《玉函》“得吐者”作“得快吐”。

80.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“少气”下均无“者”字。《脉经》、《玉函》“呕”字下亦无“者”字。《脉经》“梔子甘草豉汤主之”作“梔子甘草汤”，“梔子生姜豉汤主之”作“梔子生姜汤”，并于条后有“若腹满，梔子厚朴汤”八字。赵本本条与上78、79条（赵本为76条）合为一条。

梔子甘草豉汤方：

《玉函》、赵本、《集成》药物、剂量、煎服法，均有详细记载。

81.《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆无“而”字。《脉经》“窒”作“塞”。《脉经》、《千金翼》“梔子豉汤主之”作“属梔子汤证”。

82.《玉函》“结痛”下无“者”字；“未欲解也”句作“此为未解”。《脉经》“大下之后”无“后”字；“梔子豉汤主之”作“属梔子汤证”。

83.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“心烦”皆作“烦而”；“不安”下皆无“者”字。《脉经》“梔子厚朴汤主之”作“属梔子厚朴汤”。

梔子厚朴汤方：

赵本、《集成》梔子“十四枚”均作“十四个”。“厚朴”下《玉函》、《康平》无“姜炙”二字；赵本、《集成》作“炙，去皮”。“枳实”下《玉函》无“水浸”二字；赵本、《集成》“去穰，炒”作“炙令黄”。“已上三味”《玉函》作“右三味”；“水三升半”作“水三升”无“半”字；“分二服”作“分为二服”；“得吐”下无“者”字。《千金翼》“得吐者”三字，作“快吐”二字。

84.《玉函》、《医统》“丸”作“圆”，《千金翼》“大下之”作“大下后”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“微烦”下皆无“者”字。《康平》60、61条均列于本条下，与本条合作一条。《脉经》“梔子干姜汤主之”作“属梔子干姜汤”。

梔子干姜汤方：

赵本、《集成》梔子“十四枚”作“十四个”。《康平》干姜作“一两”。《玉函》“三升”及“一升”下均无“半”字；“分二服”作“分为二服”。《千金翼》、《玉函》“得吐者”作“得快吐”。

85.《玉函》“汤”字下有“证”字；“病”字作“其”字；“人”下无“旧”字。

86.《千金翼》、《玉函》“发汗、汗出不解”句作“发其汗而不解”。《脉经》“发汗”作“发其汗”。《脉经》、《千金翼》“发热”上无“仍”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“身^咽”下有“而”字。赵本“擗”字下有“一作僻”三小字。《脉经》“擗地”下无“者”字。《千金翼》、《康平》“真武汤”作“玄武汤”。《脉经》“真武汤主之”作“属元武汤”。

87.《玉函》“汗”字上有“其”字。《脉经》无“喉”字。《千金翼》“不可发汗”句作“忌发其汗”。

88.《千金翼》“不可发汗”作“忌发其汗”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》第二个“发”字下皆有“其”字。

89.“不可发汗”句，《脉经》、《玉函》作“不可攻其表”；《千金翼》作“忌攻其表”。赵本、《集成》“发汗”作“汗出”。《玉

函》“瘥”作“瘥”。《脉经》条后有小注云“一作瘥下同”。

90.《脉经》、《玉函》“不可发汗”作“不可攻其表”，《千金翼》作“忌攻其表”。《玉函》“汗出必额上陷，脉急紧”作“汗出必额上促急而紧”；《脉经》作“汗出必额陷，脉上促急而紧”；《千金翼》作“汗出必额上促急”，并无“直视”以下八字。《脉经》“视”字下有“而”字。《康平》“汗出”下有“则”字，“眴”上有“目”字。

91.“不可发汗”《脉经》、《玉函》皆作“不可攻其表”；《千金翼》作“忌攻其表”，第二句“发汗”三书皆作“汗出”。《康平》本条与90条合为一条。《脉经》“汗出”下为“而”字。

92.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“重发”下有“其”字。《玉函》“丸”作“圆”。《千金翼》无“与禹余粮丸”五字。《脉经》“与”字上有“可”字。赵本、《集成》“丸”下无“阙”字，有小注云“方本阙”三字。

93.《千金翼》“病人”作“病者”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“复发”下均有“其”字。《康平》“吐衄”上无“必”字。“必吐衄”下《千金翼》有“一云吐逆”；赵本有“一作逆”三小字。

94.《玉函》“此为逆也”句作“为逆”二字；“若先发汗”句作“先发汗者”。《康平》第二个“为逆”作“此为逆”。《玉函》“若先下之”句作“先下之者”。

95.“身疼痛者”《脉经》、《玉函》皆作“身体疼痛”。《脉经》“后身疼痛”亦作“身体疼痛”。《玉函》“自调”下无“者”字。

96.《玉函》“身体疼痛”作“身体更疼痛”。赵本“宜四逆汤”作“四逆汤方”四字。《脉经》、《千金翼》“病”字上有“师曰”二字，“体”字下有“更”字，“宜”字下有“温药”二字。

97.赵本、《集成》“先下”下无“之”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“发”字下有“其”字；皆无“以此”二字。《脉经》、《千金翼》无“致”字，《脉经》、《千金翼》、《玉函》“冒”字下有“当”字。“得里未和”《玉函》无“得”字，《脉经》、《千金翼》作“表和”，赵本、《集成》作“里未和”。《脉经》“然后”下无“复”字，《千金翼》“然后复下之”句作“故下之”。

98.赵本在“必先振慄汗出而解”句上有“一作微”三小字。《玉函》无“慄”字与“出”字，《脉经》无“慄”字与“而”字，《千金翼》无“慄”字；“微”字上三书皆无“脉”字；“先汗出”三书皆作“先汗之”。《千金翼》“先汗之而解”下有“宜桂枝汤”四字，无“但阴”以下十九字。《脉经》、《玉函》“下之而解”句上有“先”字。“下之而解”下《脉经》

作“属大柴胡汤证，注：阴微一作尺实”。赵本、《集成》“阴脉微”下有“一作尺脉实”五小字。《玉函》作“汗之宜桂枝汤，下之宜承气汤”。《脉经》、《千金翼》“脉阴阳俱停”上有“其”字。赵本、《集成》“调胃承气汤”下无“主之”。赵本本条后有“一云用大柴胡汤”七小字。

99.《玉函》、《集成》“荣”作“营”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》此条皆列在太阳上篇。《千金翼》“欲”作“以”。《玉函》“救”作“解”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“邪风”下皆无“者”字。“宜桂枝汤”句，《千金翼》、《玉函》皆作“桂枝汤主之”；《脉经》作“属桂枝汤证”。

100.“伤寒五六日中风，往来寒热”，《脉经》作“中风往来寒热，伤寒五六日以后”；《玉函》作“中风五六日，伤寒往来寒热”。《脉经》“心烦”作“烦心”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”作“坚”。《脉经》、《玉函》“心下悸”作“心中悸”。《脉经》、《玉函》、《千金翼》“身”作“外”。《千金翼》、《玉函》“欬”下无“者”字。《外台》“心下悸”作“心下卒悸”。《脉经》、《玉函》、赵本、《集成》“默默”作“嘿嘿”。“与小柴胡汤主之”，赵本、《集成》无“与”字；《脉经》作“属小柴胡汤证”。

小柴胡汤方：

《玉函》、赵本“黄芩”、“人参”、“甘草”下均无“三两”二字，但“生姜”在“半夏”之上，其下有“各”字，无“切”字。赵本、《集成》“甘草”下有“炙”字。赵本、《集成》、《医统》大枣皆作“十二枚”。《玉函》“味”下有“**咬**咀”二字，“再煎”作“再煮”。《千金翼》无“取三升”。《千金翼》、《玉函》“日三”下无“服”字。《玉函》“不呕”上无“而”字，下有“者”字。赵本、《集成》无“后加减法”四字；“呕”下有“者”字；“若渴者”作“若渴”。《千金翼》作“渴者”；且无“栝蒌根四两”五字；“腹中”、“胁下”之上均无“若”字。《玉函》“鞭”作“坚者”，《千金翼》亦同。《千金翼》“牡蛎”作“六两”；“心下”与“不渴”之上均无“若”字。赵本、《集成》“桂”下有“枝”字。《千金翼》、《玉函》“取微汗愈”作“微发其汗”。赵本、《集成》“覆”下无“取”字。《千金翼》“欬者”上无“若”字，“柴胡”作“八两”。

101.《千金翼》“结”作“在”。《玉函》、赵本、《集成》“默”作“嘿”。《千金翼》、《玉函》“饮食”作“食饮”。《千金

翼》“呕也”作“其呕”。《千金翼》、赵本将本条与下条并作一条。赵本“故使呕也”下有“一云藏腑相连，其病必下，胁膈中痛”十四小字。

102.《千金翼》作“服柴胡而渴者，此为属阳明，以法治之”。《玉函》“渴者”下有“此为”二字。《玉函》、赵本“属阳明”下无“也”字。

103.《千金翼》“二三”作“再三”。《千金翼》、《玉函》“而胁下”作“其人胁下”。“本渴而饮水呕者”，《千金翼》、《玉函》无“者”字；赵本、《集成》作“本渴饮水而呕者”。“柴胡汤不中与也”，《千金翼》作“柴胡复不中与也”，《玉函》作“柴胡汤不复中与也”。“小便难”《康平》作“小便黄”。

104.《脉经》、《千金翼》“身热”作“身体热”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“渴”下无“者”字。《脉经》“小柴胡汤主之”作“属小柴胡汤证”。

105.《玉函》、《千金翼》、赵本“急痛”下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“不差”下也无“者”字。“小柴胡”上《玉函》有“即与”二字；赵本、《集成》无“与”字。《千金翼》无“主之”二字。

小建中汤方：

赵本、《集成》甘草作“二两”；“内胶饴”作“内饴”。《外台》作“先煮五味，取三升，去滓，内饴，更上火微煮，令消解”；《玉函》无“微”字，亦无“日三服”三字。《集成》把“呕家不可用建中汤，以甜故也”另析为一条。《千金翼》、《玉函》“不可用”下无“建中汤”三字；“用”作“服”；“甜”作“甘”。

106.《玉函》“有柴胡证”作“有小柴胡证”。《千金翼》“悉具”下有“也”字。赵本将本条与下条（107条）并为一条。

107.《千金翼》、《玉函》“证”上无“病”字；“下之”后无“若”字。赵本、《集成》“却”下有“复”字。《千金翼》“不罢”下无“者”字，“复与柴胡汤”下有“解者”二字。

108.《玉函》“烦”下无“者”字。《外台》“二三日”作“一二日”。

109.《玉函》“反”作“及”。《脉经》、《千金翼》“二三”作“再三”；“仍在”作“续在”，其下无“者”字，《玉函》也无“者”字。“呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也”句，《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“呕止小安，一云呕不止心下急”。“下之则愈”《玉函》

无“之”字。赵本“小柴胡”下无“汤”字；“心下急”下有“一云呕止小安”六字小注。

大柴胡汤方：

《千金翼》“柴胡”作“八两”。《玉函》生姜作“三两”。赵本、《集成》无大黄；“右八味”作“右七味”。《玉函》“再煎”下有“取三升”无“日三服”。“一方用大黄二两，若不加大黄，恐不为大柴胡汤也”句，《玉函》作“一方无大黄，然不加不得名大柴胡汤也”；赵本、《集成》作“一方加大黄二两，若不加，恐不为大柴胡汤”。

110.《玉函》“日晡”下无“所”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“潮热”后无“已”字。“此本柴胡证”，《脉经》作“此本当柴胡汤”；《千金翼》作“此本当柴胡”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“下之”后无“而”字，赵本“而”作“以”。《脉经》、《千金翼》“知医以”上有“故”字。赵本、《集成》“非”上有“此”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“先宜”作“先再服”。《脉经》、《千金翼》“以解外”作“以解其外”；《玉函》无“以”字。赵本、《集成》“先宜”下有“服”字。

柴胡加芒硝汤方：

赵本、《集成》药物、剂量、煎服法均有详细记载。赵本林校尚有65字。

111.《脉经》、《千金翼》、《玉函》、赵本在“十三日”后皆无“不解”二字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“谵”字上有“而”字，“谵”字下无“者”字；“以有热也”作“内有热也”；无两个“若”字；“鞭”作“坚”。《脉经》、《千金翼》“而反下利”无“下”字，“脉调和”上有“其”字；《玉函》亦有“其”字。《玉函》“丸”作“圆”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“自下利者”无“下”字；“脉当”上有“其”字。《脉经》、《千金翼》“内实”下无“也”字。《脉经》“调胃承气汤主之”作“属承气汤证”。《千金翼》“承气汤”上无“调胃”，下无“主之”。

112.“下者愈”《脉经》作“下之即愈”；《千金翼》、《玉函》作“下者即愈”。“其外不解者”《脉经》“不”作“未”，无“者”字；《千金翼》、《玉函》亦无“者”字。《脉经》、《千金翼》、赵本、《集成》“当先

解”下有“其”字。《脉经》、《千金》、《玉函》“外解”下无“已”字，“少腹”上无“但”字。《脉经》、《玉函》“少腹”作“小腹”。《脉经》“宜桃核承气汤方”作“属桃人承气汤”。赵本注有“后云：解外宜桂枝汤”八字。

桃核承气汤方：

《玉函》作“桃仁承气汤”。“桃人五十个”赵本作“桃仁五十个”，《千金翼》、《玉函》“个”作“枚”。《千金翼》“芒硝”作“一两”。《玉函》“煮取二升半”作“先煮四味，取二升半”，“去滓”以下作“内硝更煮微沸，温服五合，日三服，微利”，《千金翼》“内芒硝”下作“更煎一沸分温三服”。

113.《外台》“下之”下有“后”字。《脉经》、《千金翼》“一身”下无“尽重”二字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“转侧”下无“者”字。《脉经》“柴胡加龙骨牡蛎汤主之”作“属柴胡加龙骨牡蛎汤”。

柴胡加龙骨牡蛎汤方：

《玉函》“**铅**丹”作“黄丹”，赵本作“铅丹”。半夏《千金翼》作“一合半”；赵本、《集成》作“二合半”，方内有“黄芩”，“生姜”下有“切”字，“牡蛎”下“煅”作“熬”；“大枣”下有“擘”字：“右十一味”作“右十二味”；“温服一升”后还有“本云柴胡汤，今加龙骨等”十字。《医统》“煅”亦作“熬”。《玉函》“切如碁子更煮一二沸”作“更煮取二升”；“本云”作“本方”；“今加龙骨等”作“内加龙骨、牡蛎、黄丹、桂、茯苓、大黄也，今分作半剂”。

114.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“满”字下有“而”字；“紧”字下有“者”字；“肝”上有“为”字；“脾”下无“也”字。《脉经》无“曰”字。《脉经》、《玉函》“刺”上有“当”字；《千金翼》“刺”上有“宜”字。

115.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“大渴欲饮水”句均作“其人大渴欲饮酢浆者”（《千金翼》“酢”作“馑”）；“满”下有“而”字；“此肝乘肺也”作“此为肝乘肺”。《脉经》、《玉函》“刺期门”上有“当”字；《千金翼》有“宜”字。

116.“反熨其背”赵本、《集成》“反”作“凡”。“反躁，反熨其背而大汗出，大热入胃”句，《脉经》作“而烧瓦熨其背，大汗出，火气入胃”；《玉函》作“而反烧瓦熨其背，而大汗出，火热入胃”。“胃中水竭，躁烦”，《脉经》作“胃中竭燥”。“必发谵语”，《玉函》作“必当谵语”。“振慄、自下利者”《脉经》、《玉函》作“振而反汗出者”。《脉经》“欲解”下无“也”字。《脉经》、《玉函》“其汗”上无“故”字。《脉经》“欲小便不得”作“其人欲小便反不得”；“呕”上无“反”字。《脉经》、《玉函》“大便鞭”作“大便坚者”。《脉经》“及不多，大便已”作“及多便已”；“头”上有“其”字。赵本、《集成》“从腰已下”之“已”作“以”。赵本在“大热入胃”句下有“一作二日内烧瓦熨背大汗出，火气入胃”十六小字。

117.《脉经》、《玉函》“太阳”下无“病”字；“发汗”作“发其汗”。《脉经》“流溢”作“流洩”。《脉经》、《集成》“阴虚”下无“则”字。《脉经》“颈项”作“齐颈”；“腹满”下有“而”字。“捻衣摸床”之“捻”字，《脉经》作“循”；《玉函》作“寻”。

118.《脉经》、《千金翼》“医”上有“而”字。《脉经》、《玉函》“惊狂”上无“必”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“起卧不安”下无“者”字。《千金翼》、《玉函》、赵本、《集成》“起卧”作“卧起”。《脉经》“桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之”作“属桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤”。

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤方：

《医统》“桂枝”下有“汤”字。赵本、《集成》“龙骨牡蛎”作“牡蛎龙骨”。赵本、《医统》、《集成》“蜀漆”下“洗去脚”作“洗去腥”。“右为末”赵本、《集成》作“右七味”。《玉函》“味”字下有“咬咀”二字。

《玉函》、《千金翼》“一斗二升”作“八升”，《玉函》无“煮取三升”之“煮”字。《千金翼》、《玉函》皆注有“一法以水一斗二升，煮取五升”。《玉函》“滓”作“渣”。赵本、《集成》“温服一升”后有“本云桂枝汤，今去芍药，加蜀漆牡蛎龙骨”十六字。《玉函》“温服一升”后有“本方桂枝汤，今去芍药，加蜀漆龙骨牡蛎。一法以水一斗二升，煮取五升”二十八字。

119.《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆无“形作”二字。《脉经》、《玉函》“者必渴”上无“弱”字。《脉经》、《千金翼》、赵本、

《集成》“被火”下无“者”字。《脉经》“^讠语”作“谗言”。《千金翼》“谗语”下无“弱者发热”以下十二字。

120.《玉函》“不得汗”下有“者”字。《脉经》“必清血”作“必有清血”。《玉函》“火邪”上无“为”字。《脉经》、《千金翼》无“名为火邪”四字。

121.《玉函》“热甚”作“热盛”，无“反”字；《脉经》亦无“反”字，“灸”上有“而”字；《千金翼》、赵本、《集成》“反”上有“而”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“必”字皆在“咽燥”下。《脉经》、《玉函》、赵本、《集成》“唾血”皆作“吐血”。

122.《千金翼》“烦逆”下无“追虚逐实……”等二十四字。赵本将本条与下两条并作一条。

123.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“宜”皆作“当”；“用火灸之”作“而反灸之”。《脉经》、《千金翼》“邪无从出”作“邪无从去”。《脉经》“必”下有“当”字。“名火逆也”，《玉函》、《脉经》、《千金翼》均作“此为火逆”。

124.《脉经》“欲”上有“若”字；“解”下无“者”字；“当”上无“必”字。《脉经》、赵本、《集成》“乃”上有“烦”字。《脉经》、《玉函》“有汗”下有“随汗”二字。“故知汗出解”《脉经》作“故知汗出当解”；《玉函》作“故知汗出而解”。《玉函》、赵本、《集成》“解”下无“也”字。

125.《脉经》、《玉函》“奔豚”作“贲豚”。“上冲心者”，《脉经》作“上撞者”；《千金翼》“冲”下无“心”字。《脉经》、《千金翼》“一壮”上无“各”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆无“更加桂二两”五字。赵本、《集成》“二两”下无“也”字。

桂枝加桂汤方：

赵本、《集成》有药物、剂量、煎服法等详细记载。

126.《脉经》“烦躁”下无“者”字；“桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之”作“属桂枝甘草龙骨牡蛎汤”。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤：

赵本、《集成》“桂枝”下有“去皮”二字；“甘草”下有“炙”字；“右为末”作“右四味”。《玉函》“甘草”、“牡蛎”、“龙骨”下皆无“二两”二字，但“牡蛎”下有“各三两”三字。《千金翼》、《玉函》“二升”下无“半”字。

127.《脉经》、《千金翼》“伤寒”上无“太阳”二字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“伤寒”下无“者”字；“惊”下无“也”字。《千金翼》“温针”作“火针”。

128.《千金翼》、《玉函》两个“恶寒”下，《脉经》第一个“恶寒”下均有“而”字。《脉经》“太阳病”下无“当”字。《玉函》、赵本、《集成》“不恶寒”上有“反”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“细数者”作“细而数”。“以医吐之过也”，《千金翼》作“此吐之过也”；《玉函》作“此医吐之故也”。《千金翼》“一二日吐之者”以下四十二字无。《脉经》“一二日”上有“若得病”三字。《脉经》、《玉函》“一”、“三”下皆有“日”字。《脉经》两个“吐之”下均无“者”字。《玉函》“暮吐”作“夕吐”。《脉经》“以”作“此”。

129.《脉经》“太阳病吐之”下有“者”字。

130.《千金翼》、《玉函》“此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也”句作“以医发其汗，阳气微，膈气虚，脉则为数”；“胃中虚冷”上无“以”字。

131.《玉函》“温温”作“嗔嗔”；“胸”上有“又”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“腹”上有“其”字；“先”下无“此”字。《千金翼》“宜调胃”作“宜”。《脉经》“承气汤”上无“调胃”二字；“不尔”上无“若”字；“欲呕”上无“但”字。《玉函》“但”作“反”字。《脉经》、《玉函》“微溏”下无“者”字。《玉函》“此非”下无“柴胡”二字，但有一“汤”字。《脉经》、赵本、《集成》“柴胡”下有“汤”字。《千金翼》无“若不尔”以下三十字。

132.《玉函》“六七日”作“七八日”。《千金翼》“日”下有“出”字。《脉经》、《千金翼》“仍”作“续”。《脉经》、《玉函》“脉微而沉”作“其脉微沉”；“狂”下无“者”字；“以热”作“此热”；“鞭”作“坚而满”。《千金翼》“当鞭”作“坚”。《玉函》“太阳”上无“以”字，并无“抵

当汤主之”五字。“抵当汤主之”，《千金翼》作“宜下之以抵当汤”；《脉经》作“属抵当汤”。

抵当汤方：

《千金翼》“大黄”作“二两破六片”；“桃仁”、“水蛭”、“虻虫”下之“个”作“枚”。赵本、《集成》“大黄”下之“酒浸”作“洗”；“右四味”下无“为末”二字；“再服”作“更服”。

133.《脉经》、《玉函》“脉”上有“其”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“少腹鞭”作“少腹坚”。《脉经》、《玉函》“不利”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》“血”下无“也”字。《脉经》“谿”下无“也”字。“抵当汤主之”，《脉经》作“属抵当汤证”；《玉函》无此五字。

134.《脉经》、《玉函》“少腹满”上有“而”字。《脉经》“今反利者，为有血也”作“而反利者，此为血”。“下之”上《千金翼》有“须”字。《脉经》无“不可余药”四字；“宜抵当丸”作“属抵当丸证”。《玉函》“丸”作“圆”。

抵当丸方：

《玉函》、赵本、《集成》“水蛭”下有“熬”字。赵本、《集成》“虻虫”作“二十个，去足翅，熬”；“桃仁”作“二十五个”。《玉函》“桃人”作“桃仁”，并作“三十个”。《千金翼》“桃仁”下有“熬”字。赵本、《集成》“杵”作“捣”；“分”下无“为”字。《玉函》“若不下”下无“者”字。《千金翼》“取七合服”下无“之”字；“当下”下无“血”字；“不下”上无“若”字，下无“者”字。《玉函》“丸”皆作“圆”。

135.《玉函》“以饮水多”作“为多饮水”；“必心下悸”作“心下必悸”。

136.《千金翼》、《玉函》“寸脉浮、关脉沉，名曰结胸也”句作“其脉寸口浮、关上自沉，为结胸”。《玉函》“何谓”上有“问曰”二字。《千金翼》“藏结”下有“答”字。“时时下利”，《千金翼》作“时下利”，《玉函》作“时小便不利”。《千金翼》、《玉函》“寸脉”作“阳脉”；“关

脉小细沉紧”作“关上细沉而紧”。《玉函》“名曰”作“为”。《千金翼》“曰”作“为”。《千金翼》、《玉函》“难治”上有“为”字。赵本、《集成》从“何谓藏结”另析为一条。

137.《千金翼》、《玉函》“结”下有“者”字。《脉经》“证”作“症”。“不往来寒热”句，《脉经》作“寒而不热”；《玉函》、赵本句下有“一云寒而不热”六字。

138.《千金翼》、《玉函》“病发”上有“夫”字；“发于阴”上无“病”字。《千金翼》第二个“下之”作“汗之”。《千金翼》、《玉函》无“所以成”三字；“以下之太早故也”作“下之早，故令结胸”。赵本将本条与下条合为一条；第二个“而反下之”下有“一作汗出”四字。

139.《千金翼》、《玉函》“项”上有“其”字。《玉函》“瘕”作“瘕”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“则和”作“即和”。《玉函》“丸”作“圆”，并无“方”字。《脉经》无“宜大陷胸丸方”六字。

大陷胸丸方：

《玉函》“丸”作“圆”；“葶苈”下无“半升熬”三字；“芒硝”下无“半升”二字；“杏人”作“杏仁”，并有“各”字，而无“去皮尖熬黑”五字。《千金翼》“大黄”下“半升”作“八两”。赵本、《集成》“葶苈”下有“子”字；“杏人”作“杏仁”。《千金翼》、《玉函》“捣”下无“筛二味，内杏人、芒硝，合研如脂，和散”十四字。《千金翼》“捣”上有“和”字。《玉函》“捣”下有“和”字；“弹丸”作“弹圆”。“甘遂”上《千金翼》、《玉函》无“别捣”二字；“白蜜”下“二合”作“一两”；“顿服”上无“温”字，下无“之”字；“一宿乃下”无“如不下更服，取下为效，禁如药法”十三字。

140.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“浮大”下无“者”字。《千金翼》“不可下”下有“之”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“则死”作“即死”。

141.《脉经》、《玉函》“烦躁”作“而躁”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“死”上无“亦”字。

142.《脉经》、《千金翼》“而反恶寒”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“表未解”上有“其”字。《脉经》、《千金翼》“表未解”下无“也”字；“变迟”作“则迟”。“膈内拒痛”句，《脉

经》、《千金翼》作“头痛即眩”；《玉函》作“头痛则眩”；《脉经》有“一云膈内拒痛”六小字。《集成》“躁烦”作“烦躁”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”作“坚”。《脉经》“大陷胸汤主之”作“属大陷胸汤”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“余处”作“其余”。《脉经》“无汗”作“无有”。《脉经》、《千金翼》“剂”作“齐”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》、赵本“发黄”下均无“也”字。《脉经》“发黄”下有“属柴胡栀子汤”六字。

大陷胸汤方：

《千金》、《千金翼》、《外台》“甘遂”下有“末”字。《千金》、《千金翼》“大黄”下无“去皮”二字。赵本、《医统》、《集成》“一钱”下有“匕”字。《千金翼》“煮一两沸”作“一二沸”；“温服一升”作“分再服”；“得快利”上有“一服”二字。《玉函》本方作“桂枝四两、甘遂四两、大枣十二枚、栝蒌实一枚去皮、人参四两。右为味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，胸中无坚，勿服之”。

143.“脉沉而紧”，《脉经》作“其脉沉紧”；《玉函》作“其脉浮紧”。《千金翼》“沉”下无“而”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“按之石鞭者”作“按之如石坚”。《脉经》“大陷胸汤主之”作“与大陷胸汤”。

144.《千金翼》“热结在里”作“邪气结在里”；“复”字上有“欲”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“热”下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“与”上有“当”字。《脉经》“与大柴胡汤”作“属大柴胡汤证”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“无大热”下无“者”字；“胸胁”下无“也”字；“头微汗”上无“但”字；“汗出”下无“者”字。《脉经》“大陷胸汤主之”作“与大陷胸汤”。

145.《脉经》、《玉函》“汗”上有“其”字。《玉函》“日晡”下无“所”字。《千金翼》“所”作“如”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”作“坚”；“近”下无“者”字。《脉经》“大陷胸汤主之”作“属大陷胸汤”。赵本“潮热”下有“一云日晡所发心胸大烦”十字。《千金翼》本条下有“若心下满而坚痛者，此为结胸，大陷胸汤主之”十八字。

146.《千金翼》、《玉函》“病”作“者”字；“则”作“即”字；“脉”上有“其”字；“滑”下无“者”字。

小陷胸汤方：

《玉函》“黄连”下“一两”作“二两”；“半夏”下无“洗”字；“栝蒌实”下无“大者”二字；“一个”作“一枚”，赵本、《集成》“个”亦作“枚”。《玉函》“去滓”作“去渣”。

147.《脉经》“不能卧”上有“终”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“起”下有“者”字；“脉”上有“其”字；“此本有寒分也”作“此本寒也”；“反”上有“而”字；“若利止”作“利止者”；“必”下无“作”字；“四日”作“四五日”；“复”下皆有“重”字。“此作协热利也”，《脉经》、《玉函》作“此挟热利也”；《千金翼》作“此为挟热利”。

148.《脉经》、《玉函》“欲解”下无“也”字；诸“脉”之上皆有“其”字；“结胸”下无“也”字；“脉细数”作“其脉细而数”；“沉紧”作“沉而紧”；“沉滑”作“沉而滑”；“协热”作“挟热”；“浮滑”作“浮而滑”。

149.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“应以”作“当以”；“汗解”下无“之”字；“反”上有“而”字，无“冷”字。《脉经》、《千金翼》“濇”作“噤”。《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“被却”作“劫”；《脉经》、《千金翼》“却”上无“被”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“益烦”上无“弥更”二字；“肉上”作“皮”；“反不渴”下无“者”字；“不差”下无“者”字。《千金翼》“服”上有“宜”字；《脉经》“服”作“宜”。《千金翼》“若不差与五苓散”七字列于方后。《集成》从“寒实结胸”另析一条。《脉经》、《玉函》“寒”上有“若”字。《千金翼》、《玉函》“与三物小陷胸汤、白散亦可服”作“与三物小白散”。《脉经》“白散亦可”下无“服”字。赵本“亦可服”下有“一云与三物小白散”八字。

文蛤散方：

《玉函》“为散”以下作“沸汤和服，一方寸匕”。赵本、《集成》“一钱”作“方寸”。《千金翼》“为散”上有“捣”字，以下作“以沸汤五合，和服一方寸匕，若不差，与五苓散。”

白散方：

《千金翼》、《玉函》“桔梗”、“贝母”皆作“十八铢”；“巴豆”作“六铢”。《玉函》“巴豆”下无“研如脂”三字。《千金翼》“为末”上有“捣”字；“杵之”作“治之”；“白饮”上无“以”字。赵本、《集成》“右”下无“件”字。赵本、《医统》、《集成》“为末”作“为散”；“半钱”下有“匕”字。《玉函》无“内巴豆，更于臼中杵之，以”十字。《千金翼》“进冷粥一杯”下有“一云冷水一杯”六字。《脉经》、赵本、《集成》“自覆”下无“者”字；“若水以”作“若以水”。赵本、《集成》“却”作“劫”。《脉经》、《千金翼》“则烦”作“即烦”。《玉函》无“身热”以下四十九字，《脉经》为四十八字，接载在经文下。

150.“头项强痛，或眩冒”句《玉函》无“冒”字；《脉经》作“头痛，颈项强而眩”；《千金翼》作“头痛或眩冒”；“如结胸”上无“时”字。“痞鞭者”《千金翼》、《玉函》作“痞而坚”；《脉经》作“痞坚”。《脉经》“大椎”作“大杼”；《千金翼》“大椎第一间”在“肺俞、肝俞”之下。“发汗则谵语脉弦”句，《脉经》、《千金翼》、《玉函》作“发汗即谵语，谵语则脉弦”。《脉经》“即”仍作“则”。“五六日”《脉经》、《千金翼》、赵本皆作“五日”；《脉经》“五日”在“谵语”之下；《玉函》“五六日”亦在“谵语”之下。

151.“得之”《千金翼》无“之”字。《脉经》“脉迟”上无“而”字。《脉经》、《玉函》“谵语”上有“其人”二字；下无“者”字；《千金翼》亦无“者”字。“血室也”《脉经》、《千金翼》、《玉函》均作“血室”，无“也”字；“随其实”皆作“随其虚实”。《脉经》、《玉函》“泻之”作“取之”。《脉经》在“取之”下有“平病云，热入血室，无犯胃气及上二焦，与此相反，岂谓药不谓针耶”廿六字；“泻之”赵本、《集成》作“取之”。

152.以上诸本皆同。

153.《千金翼》“明了”作“了了”；“状”字下无“者”字。“必”字下《千金翼》、《玉函》均有“当”字。

154.《玉函》“支节”作“肢节”；“柴胡加桂枝汤主之”下无“加”字。《千金翼》作“宜柴胡桂枝汤”；《脉经》作“属柴胡桂枝汤”；赵本、《集成》作“柴胡桂枝汤”。

柴胡桂枝汤方：

《玉函》“桂枝”下无“去皮”二字；“芍药”下无“一两半”三字；“生

姜”下有“各”字，无“切”字；“大枣”下无“擘”字。《千金翼》“以水七升，煮取三升”作“以水六升，煮取二升”；“加”字下无“半夏”。《玉函》“温服”下有“一升”二字。赵本、《集成》有“本云”以下廿七字。

155.《脉经》、《千金翼》“已发汗”上有“其人”二字。“心烦”《脉经》、《玉函》下无“者”字；《千金翼》亦无“者”字，作“而烦”。《脉经》、《千金翼》“未解”下均无“也”字。《脉经》“柴胡桂枝干姜汤主之”作“属柴胡桂枝干姜汤”。

柴胡桂枝干姜汤方：

《外台》名“小柴胡汤”。《玉函》“桂枝”下无“去皮”二字。干姜、牡蛎《玉函》、赵本、《医统》均作“二两”。《千金翼》“再煎”作“更煎”；无“取三升”三字。《玉函》无“日三服”三字。《千金翼》作“日二服”。“复服汗出便愈”句《玉函》无“便”字；《千金翼》作“汗出愈”，无“复服”、“便”字。

156.《千金翼》、《玉函》“鞭”皆作“坚”；“脉细者”皆作“其脉细”；“复有里也”皆无“也”字。“脉沉亦在里也”句《玉函》作“沉亦为病在里”；《千金翼》亦同，但“亦”字作“则”字；《集成》“在”字作“有”字。《千金翼》“汗出”下有“亦”字。《千金翼》、《玉函》“不得”下无“复”字；“悉入在”下有“于”字；“半在里半在外也”作“半在外，半在里”、无“也”字。《玉函》“少阴”下无“病”字。《千金翼》“今头汗出”作“今头大汗出”；“柴胡汤”上无“小”字，作“可与柴胡汤”。

157.《玉函》“发热”下无“者”字；“已下之”作“以下之”；“鞭”作“坚”；“结胸”下无“也”字；“但满”上有“若”字；“不中”作“不复中”；“与之”作“与也”；“半夏”上无“宜”字；“汤”字下有“主之”二字。

半夏泻心汤方：

《玉函》“半夏”下无“洗”字；“人参”下无“已上”二字；“大枣”作“十六枚”，无“擘”字；“甘草”无“三两”二字。赵本、《集成》“再煮”作“再煎”；“日三服”下有“须大陷胸汤者，方用前第二法”十二字；“第二法”下有“一方用半夏一升”七字。《外台》“半夏”下注有“一方五两”四字。

158.《玉函》“结胸”上无“成”字。“鞭”《脉经》、《玉函》皆作“坚”。“下利不止”句《玉函》作“利复不止”；《脉经》作“下利不复止”。《脉经》、《玉函》“水浆不下”皆有“肯”字；“其人心烦”句皆作“其人必心烦”。《千金翼》亦无“成”字；“鞭”亦作“坚”；“止”字上亦有“复”字；“不下”之间亦有“肯”字；“心烦”上亦有“必”字。

159.《脉经》“浮”字下无“而”字；“而”字下无“复”字。《玉函》“复”字作“反”字。

160.“下利呕逆”《千金翼》作“吐下呕逆”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“表解”下均无“者”字，“鞭”皆作“坚”。“引胁下痛”句《千金翼》无“痛”字。“干呕”《千金翼》、《玉函》作“呕即”；《脉经》作“呕则”。《千金翼》、《玉函》均无“汗出不恶寒者”六字；《脉经》“寒”字下无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“此”字下皆有“为”字；“和”字下皆无“也”字。《脉经》“十枣汤主之”作“属十枣汤证”。

十枣汤方：

《玉函》、赵本、《集成》无“大枣”一药，“右”字下无“上”字。《玉函》无“各别捣”三字。《千金翼》无“等分，各别”四字；“一升半”作“一升五合”。《玉函》“枣”字上无“大”字；无“肥者”二字。《千金翼》亦无“肥者”二字。“内药末，强人服一钱匕”《千金翼》作“强人内药末，一钱匕”。《玉函》无两“服”字和“匕”字。“羸人服半钱”《千金翼》作“羸人半钱匕”。《玉函》无“温服之平旦服”六字；“不除”下无“者”字；“明日”下无“更服”二字；无“得快”以下九字。《千金翼》“温服”下无“之”字，“病不除者”作“不利者”，“明日”作“明旦”，“得快下”下无“利后”二字。

161.“医发汗”句《千金翼》无“医”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“汗”字上均有“其”字。《脉经》“恶寒”上有“而”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“复”字上皆无“因”字；“心下痞”上皆有“则”字。《脉经》、《千金翼》“表”字上有“此”字。《脉经》“烧针”作“火针”。《集成》“胸烦”上无“因”字，《脉经》作“因而烦”。“肤_𦵏者，难治”句《脉经》、《玉函》作“肤_𦵏，如此者为难治”；《千金翼》作“肤_𦵏，此为难治”。《脉经》、《千金翼》“愈”字上无“易”字。

162.《千金翼》“濡”字上有“自”字，“其脉关上浮者”句《千金翼》

作“关上脉浮者”，《玉函》“浮”字上有“自”字；“浮”字下无“者”字。

大黄黄连泻心汤方：

《玉函》方名作“大黄泻心汤方”；“味”字下有“~~咬~~咀”二字。《千金翼》“再服”下有“此方必有黄芩”六字，赵本林校“再服”下有“臣亿等看详大黄黄连泻心汤，诸本皆二味，又后附子泻心汤，用大黄黄连黄芩附子，恐是前方中亦有黄芩，后但加附子也，故后云，附子泻心汤，本云加附子也。”

163.《玉函》“心下痞”上有“若”字。

附子泻心汤方：

《集成》“附子”作“二枚”；《千金翼》无“去皮破”三字。《玉函》“味”字下有“~~咬~~咀”二字；“三味”上无“切”字。《千金翼》无“切三味”三字。

164.《脉经》、《千金翼》“与泻心汤”句作“与之泻心”，“痞不解”上均有“其”字。《脉经》“燥”字下无“烦”字。“五苓散主之”《脉经》为“属五苓散”；《千金翼》、《玉函》、赵本“主之”之下，《脉经》“五苓散”下皆有“一方云，忍之一日乃愈”，但《脉经》、《千金翼》“云”作“言”；《千金翼》“乃愈”下有“用上方”三字；赵本有“用前第七证方”六字。

165.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”皆作“坚”；“下利”作“而利”；全无“者”字。《脉经》“生姜泻心汤主之”作“属生姜泻心汤”。

生姜泻心汤方：

《玉函》“生姜”下无“切”字；“甘草”下无“三两”，“炙”字；“人参”下无“三两”二字；“干姜”下无“一两”；“黄芩”下有“各”字，但在“甘草”之下；“半夏”下无“洗”字；“黄连”下有“各”字，但在“干姜”之下。赵本、《集成》有“附子泻心汤”、“本云”以下四十三字，《千金翼》

无“再煎取三升”五字。

166.《外台》“谷”字上有“水”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“痞鞭”作“痞坚”；“心烦”作“而烦”。《脉经》、《千金翼》、《外台》“不得安”作“不能得安”。《脉经》、《千金翼》“谓”作“为”；“复”字下有“重”字。《玉函》、《脉经》、《千金翼》“但”字下无“以”字；“使鞭也”皆作“使之坚”。《外台》亦同《脉经》“甘草泻心汤主之”作“属甘草泻心汤”。

甘草泻心汤方：

《玉函》“半夏”下无“洗”字；“大枣”下无“擘”字。《外台》“干姜”作“二两”；“半夏”“洗”字下有“去滑”二字。《千金翼》、《外台》方下有“一方有人参三两”七字。“日三服”下赵本林校有“臣亿等谨按上生姜泻心汤法，本云，理中人参黄芩汤，今详泻心以疗痞，痞气因发阴而生，是半夏生姜甘草泻心三方，皆本于理中也，其方必各有人参，今甘草泻心汤中无者，脱落之也，又按《千金》并《外台》治伤寒^蠶食，用此方皆有人参，知脱落无疑”。

167.《脉经》“下利”上有“而”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”皆作“坚”。《千金翼》“泻心汤”下无“已”字。《脉经》“复”作“后”。《脉经》、《千金翼》“理中”下无“者”字。《千金翼》“理中焦”作“治中焦”；《脉经》“焦”作“焦”；“赤石脂”上有“属”字，“汤”下无“主之”二字。“复利不止者”《脉经》、《玉函》作“若不止者”；赵本、《集成》“复”下无“利”字；《千金翼》无“复不止者”以下九字，但于方后有“若不止，当利小便”七字。

赤石脂禹余粮汤方：

《集成》禹余粮上有“太乙”二字；《千金翼》、赵本“太乙”作“太一”。“已上二味”《玉函》、赵本、《集成》作“右二味”。“二升”上《玉函》无“取”字。《玉函》、赵本、《集成》有“分温”二字，《千金翼》“三服”下有“若不止当利小便”七字。

168.《脉经》、《千金方》“吐下”下无“后”字；“鞭”作“坚”。《玉函》“鞭”亦作“坚”。

169.《脉经》、《玉函》“发汗”皆作“汗出”。《千金翼》无两“若”字。《脉经》“下”字上无“若”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”皆作“坚”。赵本“赭”下无“石”字。《玉函》“复”作“覆”。《脉经》“旋复代赭石汤主之”作“属旋复代赭汤”。

旋覆代赭石汤方：

赵本、《集成》“赭”字下无“石”字；“生姜”下无“切”字；《玉函》“生姜”下无“切”字；“半夏”下无“洗”字；“大枣”下无“擘”字；“甘草”作“二两”并无“炙”字。《玉函》、赵本、《集成》“七味”上无“件”字。《千金翼》无“再煎取三升”五字。

170.“下后”《玉函》作“大下之后”；《脉经》作“大下已后”；《脉经》无“若”字与“者”字。《脉经》、《玉函》“可与”作“可以”；“杏子”作“杏仁”。

171.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“协”作“挟”；“不止”上无“利”下二字；“鞭”皆作“坚”。《脉经》、《千金翼》“不解”下无“者”字。《脉经》“桂枝人参汤主之”作“属桂枝人参汤”。

桂枝人参汤方：

赵本、《集成》桂枝下“去皮”作“别切”。《玉函》“桂枝”下无“四两去皮”四字；“甘草炙”下有“各”字；“白术”下无“三两”二字；“人参”下无“三两”二字；“干姜”下有“各”字。《千金翼》“白术、人参、干姜”各作“二两”。《玉函》“九升”下无“先”字；“内桂”上有“去滓”二字；《千金翼》亦有此“去滓”二字。《玉函》、赵本、《集成》“温服”上有“去滓”二字。

172.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“汗”字上有“其”字。《脉经》、《千金翼》“不可攻”下亦有“其”字。《玉函》“解”上无“表”字；“乃可攻”下有“其”字。《脉经》、《千金翼》“乃”字下无“可”字；“攻”字下亦有“其”字。《脉经》两“宜”字俱作“属”字。《千金翼》无“解表宜桂枝汤，攻痞”八字。

173.《千金翼》、《玉函》“鞭”作“坚”；“呕吐”下皆无“而”字。《千金翼》“心下”作“心中”。《脉经》“不解”下有“后”字；“鞭”亦作“坚”；“呕”下无“吐”字；“利”下无“者”字，并无“主之”二字。

174.《脉经》“头”字上有“其”字。《千金翼》“头不痛，项不强”句作“头项不强痛”；“脉”字上无“寸”字。《脉经》“寸”字下有“口”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”字皆作“坚”字。《脉经》“冲”作“撞”。《千金翼》、赵本“咽喉”作“喉咽”。“息”字下《脉经》、《千金翼》皆无“者”字；“寒”字下同无“也”字。《脉经》无“宜瓜蒂散”四字。

瓜蒂散方：

《玉函》“瓜蒂，赤小豆”各作“六铢”；“散”字下无“已”字。《千金翼》作“右二味，捣为散，取半钱匕，豉一合汤七合渍之，须臾去滓，内散汤中，和顿服之，若不吐，稍加之，得快吐，止，诸亡血虚象，不可与瓜蒂散”并“瓜蒂熬”字下无“黄”字。

175.“病”字下《玉函》有“者若”二字；《脉经》有“者”字。“连在脐旁”《脉经》作“而下在脐傍”。“入阴筋者”句《脉经》、《玉函》俱作“入阴侠阴筋者”，但《脉经》无“者”字。《脉经》、《玉函》“此名”作“此为”。

176.《脉经》、《玉函》、赵本、《集成》“伤寒”下无“病”字。《脉经》、《千金翼》“吐”字、“下”字上均无“若”字；“数升”下亦无“者”字；“白虎加人参汤”作“白虎汤”，《脉经》作“属白虎汤”。

177.《千金翼》、《玉函》“心烦”作“而烦”；“背”字上均有“其”字。《千金翼》“白虎加人参汤”作“白虎汤”；“恶寒”下无“者”字；《千金方》、《外台》“白虎加人参汤”亦皆作“白虎汤”。

178.《千金翼》、赵本“不解”下无“者”字；《千金翼》“无表证”下亦无“者”字。《千金翼》、《玉函》、《千金方》、《外台》“白虎加人参汤”俱作“白虎汤”。

179.《千金翼》、《玉函》“太阳”下有“与”字；“鞭”作“痞坚”二字。《玉函》“颈”作“头”。“眩”字下《千金翼》、《玉函》皆无“者”字。《千金翼》“当刺”作“宜刺”。《玉函》“大椎”下有“第一间”三字。《千金翼》无“慎”字。

180.《千金翼》“黄芩加半夏”上有“与”字；“汤”字下无“主之”二字。

黄芩汤方：

《玉函》“黄芩”下无“三两”二字；“大枣”下无“擘”字；“夜”字上有“服”字。赵本、《集成》“一服”下无“若呕者，加半夏半升，生姜三两”十二字。

黄芩加半夏生姜汤方：

《玉函》、赵本、《集成》有黄芩加半夏生姜汤方，药物、剂量、煎服法均有详细记载。

181.《千金翼》、《玉函》“吐”字下无“者”字。

黄连汤方：

《玉函》“黄连、桂枝”皆作“二两”；“甘草、干姜”皆作“一两”；“半夏”作“五合”，并下无“洗”字；“大枣”下无“擘”字；“温服一升”作“分五服”，《千金翼》作“温分五服”。赵本、《集成》“温服”下有“昼三夜二，疑非仲景方”九大字。

182.《脉经》“疼烦”作“疼痛”；“脉浮虚而涩者”句《千金翼》作“下已，脉浮而紧”。《脉经》、《玉函》将本条与下条并为一条。

183.《千金翼》、《玉函》“鞭”作“坚”；“小便自利”下无“者”字。赵本、《集成》“桂”字下无“枝”字，《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“术附子汤”。赵本“大便鞭”下有“一云脐下心下鞭”七小字。

桂枝附子汤方：

赵本、《集成》“附子”“破”下无“八片”二字。《玉函》“桂枝”下无“去皮”二字；“附子”下无“去皮破八片”五字；“生姜”下无“切”字；“大枣”作“十五枚”，下无“擘”字。

去桂枝加白术汤方：

《玉函》名“术附汤方”并有详细记载。

赵本、《集成》有去桂加白术汤方，药物、剂量、煎服法均有详细记载。

184.《脉经》、《玉函》、赵本、《集成》“烦疼”作“疼烦”。《千金翼》、《玉函》“微肿”下无“者”字。

甘草附子汤方：

《玉函》“甘草白术”皆作“三两”；“附子”下无“去皮破”三字；“桂枝”下无“去皮”二字。《外台》“甘草”亦作“三两”。《千金翼》“白术”作“三两”。“初服得微汗则解”句《玉函》作“汗出即解”。《千金翼》“则解”作“即止”。《玉函》、赵本、《集成》“能食汗出”作“能食汗止”；“服”上无“将”字。《玉函》“妙”作“始”。《千金翼》、赵本、《集成》“为妙”二字作“愈”字。

185.赵本、《集成》“此”字下有“以”字。本节《玉函》作“伤寒脉浮滑，而表热里寒者，白通汤主之，旧云白通汤，一云白虎者恐非”；“恐非”下并有“旧云以下出叔和”七字小注。

白虎汤方：

赵本、《集成》“甘草二两”下有“炙”字。《外台》“甘草”作“三两炙”；“四味”下有“切”字，以下作“以水一斗二升煮取米熟，去米内药，煮取六升，去滓，分六服、日三服，忌海藻菰菜”。赵本林校“臣亿等谨按前篇云：热结在里，表里俱热者，白虎汤主之。又云：其表不解，不可与白虎汤。此云脉浮滑，表有热，里有寒者，必表里字差矣。又阳明一证云：脉浮迟，表热里寒，四逆汤主之。又少阴一证云：里寒外热，通脉四逆汤主之。以此表里自差明矣。《千金翼》云：白通汤非也。”

186.“心动悸”句《玉函》作“心中惊悸”。

炙甘草汤方：

《玉函》“生姜”下无“切”字；“麻子仁”作“麻子仁”；“大枣”作“三十枚”；“大枣”下无“擘”字。赵本、《集成》、《医统》“大枣”作“三十枚”；“麦冬”作“半升”。《千金翼》“生地黄一斤”下有“切”字。《玉

函》“酒”字上无“以清”二字。《玉函》皆无“先煮八味”四字。《玉函》无“消”字。《千金翼》“烱消”作“消烱”。《千金翼》、《玉函》均无“一名复脉汤”五字。

187.《玉函》中无此节经文，赵本“时一止”上无“而”字。赵本“复动”下有“者”字。

188.《玉函》“少阳阳明”作“微阳阳明”；“脾约”下有“一作脾结”四字。赵本“脾约”下有“一云络”三字。

189.赵本“胃家实”下有“一作寒”三字。

190.《千金翼》、《玉函》之“少阳”皆作“微阳”；“发汗利小便已”句皆作“发其汗，若利其小便”而无“已”字；“胃中燥”下皆无“烦实”二字。《千金翼》“便难”上无“大”字。以上188、189、190三条，赵本、《集成》皆合为一条。

191.赵本“胃家实”下有“一作寒”三字。《玉函》、赵本、《集成》“胃家实”下有“是”字。《玉函》本条列在阳明篇第一条。《千金翼》“胃家实”作“胃中寒”，亦列为第一条。

192.“若发汗、若下、若利小便，此亡津液”句，《千金翼》、《玉函》作“发其汗，若下之，亡其津液”，无“利小便”字样。《千金翼》“转属”作“为”字。“内实大便难者”句，作“而便难复”四字。“此名阳明也”句，《千金翼》、《玉函》皆作“为阳明病也”。

193.《千金翼》、《玉函》“汗”字下无“自”字；“不”字上有“而”字；“反”字上有“但”字。《千金翼》结句无“也”字。

194.《千金翼》“发热”上无“不”字。《玉函》“发热”作“恶热”。《千金翼》“恶寒”上无“而”字；“何”字下无“也”字。《玉函》“何也”作“云何”。《千金翼》、《玉函》“虽”字上皆有“然”字；“虽”字下而无“得之”二字。《千金翼》第二个“一日”作“二日”。《千金翼》、《玉函》“恶寒”下无“将”字；“即”字下无“自”字；“汗出”下无“而”字。

195.《千金翼》无“问”字；“居”作“处”；“土”字上有“主”字，下无“也”字。赵本、《集成》“土”字上有“主”字。《千金翼》“病”字下无“也”字。

196.《千金翼》无“本”字；“不彻”上有“复”字；“阳明”下无“也”字。赵本本条与下条合为一条。

197.《千金翼》、《玉函》“伤寒”作“病”字；“濇濇然”下无“者”字；“是”字下皆有“为”字。《千金翼》“属”字作“在”字。“阳

明”下《千金翼》、《玉函》皆无“也”字。

198.《玉函》中此条在“辨太阳病形证治第三”中，而不在阳明篇；“脉大”下有“者”字，其下复有“为欲传”三字。

199.《千金翼》“伤寒”作“病”字；“手足”下无“自”字。《千金翼》、《玉函》“温”字下无“者”字；“太阴”下无“者”字。《千金翼》“当发黄”上无“身”字；“小便”上无“若”字。“大便鞅者，为阳明病也”句，《千金翼》作“而坚为属阳明”；《玉函》作“便坚，为属阳明”。

200.《千金翼》“转”作“传”。《玉函》“濇然”作“濇濇然”。《千金翼》“微汗”作“后汗”；“出”字下无“也”字。

201.《千金翼》“而紧”作“若紧”。《玉函》无“而”字。《千金翼》“下之”上无“若”字。

202.《千金翼》、《玉函》“能食”上皆无“若”字；两“名”字皆作“为”字。

203.《千金翼》、《玉函》“中寒”上皆无“若”字。赵本、《集成》“中寒”下有“者”字。《千金翼》、《玉函》“小便不利”上皆有“而”字；“固瘕”皆作“坚瘕”。《千金翼》“瘕”字下有“也”字；“必”字下无“大便”二字；“初”作“头”；“鞅”作“坚”。《玉函》“鞅”亦作“坚”。《千金翼》、《玉函》“胃中冷”上皆无“以”字。

204.《玉函》、赵本、《集成》“欲食”上有“初”字。《千金翼》“欲食”上有“为”字，下有“之”字。《玉函》“小便”上复有“食之”二字。《千金翼》、《玉函》“不利”皆作“不数”；“而解”下同无“者”字；“此”字下同有“为”字。“脉紧则欲”句，《千金翼》作“坚者即愈”。《玉函》“则”作“即”。

205.“从申至戌上”句，《千金翼》、《玉函》同作“从申尽戌”，无“上”字。

206.《千金翼》“不能食”下有“下之不解，其人不能食”九字。“其人本虚”上，《千金翼》、《玉函》皆无“以”字。第二个“攻其热必哕”上，赵本、《集成》皆无“故”字。

207.“饱则微烦”《千金翼》“则”作“即”；“头眩”下有“者”字；《玉函》作“饱即发烦”。赵本、《集成》“疸”字皆作“瘕”。“腹满如故”句《千金翼》作“其腹必满如故耳”。

208.《千金翼》、《玉函》“阳明病”下有“久而坚者”五字。“法多汗”句，《玉函》作“阳明当多汗”；《千金翼》作“阳明病当多汗”。“反

无汗”上《千金翼》、《玉函》皆有“而”字。“皮中状者”，《千金翼》、《玉函》皆作“皮中之状”。《千金翼》“此以”作“此为”。《医统》“此以”作“以此”。

209.“阳明病”上《玉函》有“各”字；《千金翼》有“冬”字。“而小便不利”《千金翼》作“但小便不利”；《玉函》作“而但小便”。《千金翼》、《玉函》“手足厥者”句皆作“手足若厥者”；“必苦头痛”皆作“其人头必痛”；“不欬不呕”二书皆作“不呕不欬”。《玉函》“头不痛”上有“其”字。赵本“头不痛”下有“一云：冬阳明”五字。

210.“阳明病”上《千金翼》有“冬”字；《玉函》有“各”字。《千金翼》“能食而欬”下有“者”字。《千金翼》、《玉函》、赵本、《集成》“必咽痛”句作“咽必痛”。《玉函》“咽不痛”上有“其”字。赵本“咽不痛”下有“一云冬阳明”五字。

211.《千金翼》“懊^怏”下无“者”字；“必发黄”上无“身”字。《玉函》“必发黄”上亦无“身”字。

212.赵本、《集成》“小便不利”之上有“而”字。《千金翼》“而小便不利”下无“者”字。

213.《千金翼》、《玉函》“脉浮而紧”下皆无“者”字；“必潮热”句皆作“其热必潮”。

214.《千金翼》“噯”作“咽”。《千金翼》、《玉函》“必衄”上皆无“此”字。

215.《千金翼》、《玉函》“医更”作“医复”。《千金翼》“汗”字上有“其”字。《玉函》“差”作“瘥”。《千金翼》、《玉函》“尚”作“其人”。《千金翼》“了了”下无“者”字。“此大便必鞭故也”句，《千金翼》、《玉函》作“此大便坚也”，赵本、《集成》作“此大便鞭故也”。“以亡”《千金翼》作“必亡”。“津液”《玉函》作“精液”。《千金翼》、《玉函》“燥”字上皆无“干”字。“故令大便鞭”《千金翼》、《玉函》作“故令其坚”。《千金翼》“当问”下无“其”字。“若本”下《千金翼》、《玉函》无“小便”二字；“今日再行”下同有“者”字。“故知”《玉函》作“知必”；《千金翼》无“故”字。“津液”上《千金翼》、《玉函》同无“以”字。“故知不久必大便也”句《千金翼》、《玉函》作“故知必当大便也”。

216.《千金翼》“攻之”作“攻也”。《脉经》“证”作“症”。

217.《脉经》、《千金翼》“心下”上有“当”字。“鞭满者”《脉经》、《千金翼》、《玉函》作“坚满”，而无“者”字；“利遂”三书皆

作“遂利”。“不止者”下《千金翼》无“死”字。“止者愈”上《脉经》、《玉函》无“利”字。

218.《千金翼》“合赤色”上无“面”字。赵本、《集成》“面合赤色”作“色赤”。《脉经》作“身合色赤者”。《玉函》、《医统》“必发热”上复有“攻之”二字。“色黄”下《脉经》、《千金翼》、赵本、《集成》皆有“者”字。

219.《千金翼》、《玉函》“不吐不下”作“不吐下”；“心烦”作“而烦”。《千金翼》无“调胃”二字，但曰“可与承气汤”。《脉经》亦作“不吐下而心烦者，可与承气汤”。

220.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“脉迟”上有“其”字。《脉经》“虽汗出”下有“而”字。《脉经》、《千金翼》“不恶寒”下皆无“者”字；“其身”作“其体”。《脉经》“其体”下有“一本作人”四字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“潮热”下均无“者”字。“此外欲解，可攻里也”句，《脉经》、《千金翼》作“如此者，其外为解，可攻其里”；《玉函》作“如此者，其外为欲解，可攻其里也”。《脉经》“手足”上有“若”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》、赵本“濇然”下全无“而”字。《千金翼》、《玉函》“汗出”下无“者”字。“此大便已鞭也”《千金翼》、《玉函》作“此为已坚”；《脉经》作“此大便已坚”。“大承气汤主之”一句，《千金翼》作“承气汤主之”；《脉经》作“属承气汤”，并无“若汗多微发热恶寒者，外未解也”十三字。《千金翼》、《玉函》“若汗”下有“出”字。《千金翼》“微”字上有“而”字；“微”字下无“发热”二字；“恶寒”下无“者”字。“外未解也”《千金翼》、《玉函》作“外为未解”。赵本“外未解也”下有“一法与桂枝汤”六字。《千金翼》“未可”作“勿”。《脉经》“大满”作“满大”。“不通者”《脉经》、《千金翼》作“而不大便者”。“可与”《脉经》作“属”字。“微和”下《千金翼》、《玉函》有“其”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》、赵本、《集成》“勿令”下皆有“至”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“下”字上皆无“泄”字。

大承气汤方：

《千金翼》、《外台》“大黄”下无“酒洗”二字。《千金翼》“厚朴”作“八两”，无“去皮”二字。《千金翼》、《玉函》“先煮二物”作“先煮二味”。《千金翼》“内大黄”上无“去滓”二字。赵本、《集成》“煮取

二升”上有“更”字。“更上微火一两沸”《千金翼》作“更煎一沸”。“微火”《医统》作“火微”。《千金翼》“再服”上无“温”字；“得下，余勿服”作“得下者止”。

小承气汤方：

《玉函》、赵本、《集成》“已上”作“右”字。赵本“大黄四两”下有“酒洗”二字。“分温二服”《玉函》作“分温三服”；《千金翼》作“分温再服”。“初服”下《玉函》无“汤”字；《千金翼》有“谵语即止服”五字。“不尔”下《千金翼》、《玉函》均无“者”字。“尽饮之”《千金翼》作“尽服之”。“若更衣”下《玉函》无“者”字；“勿服之”作“勿复服”。

《千金翼》无“若更衣者，勿服之”七字。《外台》“分温二服”下作“若一服得利，谵语止，勿服之”。

221.“鞭”《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“坚”。“大便微鞭者”句《脉经》、《千金翼》俱作“微坚”二字，而无“大便”、“者”三字；“可与”下二书皆无“大”字；“不鞭”作“不坚”，其下亦皆无“者”字。“不与之”《脉经》作“不可与”；《千金翼》、《玉函》皆作“勿与之”；赵本、《集成》作“可与之”。《千金翼》“六七日”作“六十日”。《脉经》“少与”，上有“可”字。《千金翼》、《玉函》“少”皆作“可”。“汤入腹中”句《脉经》无“汤入”二字；《千金翼》作“若腹中”。《玉函》“失气”皆作“矢气”。“此有燥屎”句《玉函》作“为有燥屎”；《脉经》、《千金翼》作“此为有燥屎”；赵本、《集成》“燥屎”下有“也”字。“此但初头鞭，后必溏”句《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“此但头坚后溏”。《千金翼》“胀满”上有“腹”字。《脉经》“胀”作“腹”。“不能食”下《脉经》、《千金翼》皆无“也”字；“与水则哕”句二书皆无“与水”二字；“则”作“即”；《玉函》亦将“则”作“即”。“发热者”《玉函》作“发潮热”；“热”字后无“者”字。“必大便复鞭而少也”句《玉函》作“必复坚而少也”；《脉经》、《千金翼》作“必复坚”，无“而少也”三字。“不转失气”上《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆无“若”字。“慎不可攻也”《脉经》、《千金翼》皆作“慎不可攻之”。

222.《脉经》、《玉函》、赵本、《集成》“郑声”下皆有“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“重语”下皆有“是”字。

223.《脉经》、《玉函》“下利”上有“若”字。赵本、《集成》将

222、223两条合为一条。《外台》“郑声者，重语也”六字为小注。

224.《玉函》“若重发汗者”句作“重发其汗”；“亡其阳”上有“若已下，复发其汗”七字。《脉经》“谵语脉短”上为“发汗多，又复发其汗，此为亡阳，若”十三字。

225.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“吐”、“下”上均无“若”字。“不解”《脉经》、《千金翼》作“未解”；“至”字上二书皆无“上”字；“日晡”上二书均有“其人”二字。《玉函》“所”作“时”。《千金翼》“独语”但作一“犹”字。“鬼”字下《脉经》、《千金翼》皆有“神之”二字。《千金翼》“剧者”上无“若”字。“摸床”《脉经》作“妄撮”；《千金翼》作“妄掇”；《玉函》做“撮空”。“惕而”《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“怵惕”。“谵语”下《脉经》、《千金翼》全无“者”字。“大承气汤主之”《脉经》作“属承气汤”；《千金翼》作“与承气汤”。“若一服利，止后服”句赵本、《集成》作“则止后服”。《脉经》、《千金翼》作“若下者，勿复服”。赵本“惕而不安”下有“一云顺衣妄撮、怵惕不安”十字。

226.《脉经》“多汗”作“汗多”。《脉经》、《千金翼》“津液”上无“以”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”皆作“坚”。《脉经》“鞭则谵语”作“坚者必谵语”。《千金翼》但作“承气汤”而无“小”字；《脉经》“属承气汤证”。《千金翼》“则谵语”上有“者”字；无“若一服”以下十字。《脉经》也无此十字。《玉函》“一服”上无“若”字。赵本、《集成》“谵语止”下有“者”字。《玉函》“莫复服”上无“更”字。

227.《千金翼》“谵语”下有“妄言”二字。“脉滑”上《玉函》有“其”字。《脉经》、《千金翼》“脉滑而疾者”“小承气汤主之”二句，作“其脉滑疾，如此者属承气汤”；《千金翼》作“如此者承气汤主之”。《玉函》“失气”作“矢气”。《千金翼》、赵本第一个“转”字下皆无“失”字。“更服”《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“复与”。“若不转”《脉经》、《千金翼》作“如不转”；赵本作“若不转气者”。《脉经》、《集成》第二个“失气”下有“者”字。《千金翼》“勿”字下无“更”字。《脉经》、《千金翼》、赵本、《集成》“不大便”上有“又”字。《千金翼》“微涩”下无“者”字。“里虚也”《脉经》、《千金翼》作“此为里虚”。“不可更与”《千金翼》作“不得复与”。《脉经》、《千金翼》“汤”字下皆无“也”字。

228.《玉函》“反不能”上有“而”字；《脉经》亦同。《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆无“胃中”二字。“五六枚”下《脉经》、《千金

翼》皆无“也”字。“但鞭耳”《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“但坚耳”。“宜大承气汤下之”句《脉经》作“属承气汤证”；《千金翼》作“承气汤主之”；《玉函》作“大承气汤主之”。

229.《脉经》、《千金翼》“下血”下有“而”字。《脉经》“谵语”下无“者”字。“刺期门”上《脉经》、《玉函》皆有“当”字。《千金翼》、赵本、《集成》“泻”作“写”字。“濺然”《集成》作“濺濺然”。《脉经》“则愈”上皆有“者”字。《千金翼》“泻之”下无“濺然汗出则愈”。

230.“汗”下赵本有“一作卧”三字。《脉经》、《千金翼》“汗出”下有“而”字；“有燥屎”上无“以”字；“风”上无“为”字；“风也”下无“须下之”三字。赵本“须下之”作“须下者”。《脉经》“语言”下无“必”字。《玉函》“里实”作“里热”。《千金翼》“里实”下无“故也”二字。赵本无“下之则愈”之“则”字。“宜大承气汤”句《脉经》“属大柴胡汤承气汤证”；《千金翼》作“宜承气汤”而无“大”字；赵本“汤”字下有“一云大柴胡汤”六字。

231.《脉经》“脉沉”上有“其”字，下有“烦”；“沉为在里”句作“脉沉者，病为在里”；“反发其汗”上无“而”字。

232.《脉经》、赵本“口不仁”下无“而”字；《千金翼》“而面垢”作“言语向经”四字。赵本“面垢”下有“又作枯一云向经”七字。“尿”《脉经》、《玉函》作“溺”。《玉函》“发汗则谵语”下有“甚”字。“逆冷”《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“厥冷”。《千金翼》无“若自汗出者”五字。《脉经》“若自汗出者，白虎汤主之”作“自汗，属白虎汤证”。《千金翼》“主之”下有“按诸本皆云向经不敢刊改”十一字。

233.“下之则愈”《玉函》“则”作“即”，《脉经》无“则”字；“宜大承气汤”作“属承气汤证”。

234.“脉浮而紧”《脉经》、《玉函》作“其脉浮紧”；《千金翼》作“脉浮紧”。“咽燥”以上三书皆作“咽乾”。《脉经》“不恶寒”上有“而”字。“反恶热”《脉经》、《千金翼》同作“反偏恶热”；“身重”二书同作“其身体重”。“若发汗则躁”句《脉经》、《玉函》同作“发其汗即躁”；《千金翼》作“发汗即躁”。《千金翼》“愤愤”上有“中”字，下有“而”字。《脉经》亦有“而”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“加烧针”上无“若”字。赵本、《集成》“烧针”作“温针”。《脉经》、《千金翼》“烦躁”上有“又”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“下之”上亦无“若”字。《千金翼》“胃中”上无“则”字；《脉经》、《玉函》“则”作“即”。《千金翼》“栀子豉汤主之”作“栀子汤”而

无“豉”字。《脉经》作“属栀子汤证”。

235.《千金翼》、《玉函》“白虎”下无“加人参”三字，但作“白虎汤主之”。

236.《千金翼》“小便不利”下无“者”字。《玉函》、《集成》将234、235、236三条合为一条。

猪苓汤方：

《千金翼》“猪苓”下“去皮”作“去黑皮”。《玉函》“猪苓”下无“去皮”二字；“滑石”下有“各一两”三字；而“泽泻”下无“各一两”三字。《千金翼》、《玉函》“内下阿胶”作“内胶”；赵本、《集成》作“内阿胶”。《玉函》“烱消”作“消尽”。《外台》“阿胶”下有“炙”字，“滑石”下有“绵裹”二字。

237.以上所校各书，原文皆同。

238.“脉浮而迟”《千金翼》作“若脉浮迟”；“清谷”下无“者”字。

239.“若胃中虚冷”上《脉经》有“阳明病”三字；《千金翼》无“若”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“不能食”上皆有“其人”二字。《脉经》、《玉函》“不能食”下均无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“则”皆作“即”。

240.《千金翼》、《玉函》“能食者则衄”作“能食者即衄”。

241.《千金翼》“饥”字上有“若”字。《脉经》有“苦”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“汗出”下均无“者”字。“栀子豉汤主之”《脉经》作“属栀子汤证”。《千金翼》无“豉”字，作“栀子汤主之”。

242.《千金翼》、《玉函》“胸胁”上有“而”字。《千金翼》“不去”下无“者”字。“小柴胡汤主之”赵本、《集成》作“与小柴胡汤”。

243.《千金翼》、《玉函》“鞭”作“坚”。《千金翼》“胎”字上无“白”字；“可与”作“可以”。“而汗出解也”《玉函》“而”在“汗出”之下，并无“也”字；《集成》作“汗出而解也”；《千金翼》、赵本“而解”下皆无“也”字。

244.《脉经》“气不通”下有“一作按之不痛”六字。“嗜卧”上《千金翼》、《玉函》有“其人”二字。“一身及面目悉黄”《脉经》、《千金翼》、赵本、《集成》皆无“面”字。《玉函》“外不解”上有“其”字。

《脉经》、《千金翼》“脉续浮者”句无“者”字；“但浮”上皆无“脉”字。《玉函》亦无此“脉”字。“无余证”下《脉经》、《千金翼》亦无“者”字。“若不尿”句，《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆无“若”字；“尿”作“溺”。《玉函》“加哕”作“加喘”。《脉经》、《千金翼》“加哕”下无“者”字。

本条经文赵本作为二条，“阳明中风……与小柴胡汤”为一条，“脉但浮……不治”为另一条。

245.《千金翼》“汗出”上无“自”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“若发”下皆有“其”字；“小便自利”下皆无“者”字。《脉经》、《千金翼》无“津液”二字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“鞭”皆作“坚”。《千金翼》“不可攻”下无“之”字。《玉函》“蜜”作“密”。《千金翼》、《玉函》“猪胆汁”上无“及与大”三字；《脉经》无“与大”二字；赵本、《集成》“及”字下无“与”字。《脉经》、《千金翼》“为导”作“以导”。

蜜煎导方：

赵本、《集成》作“蜜煎方”而无“导”字；“蜜”作“食蜜”。“七合”赵本作小字。《玉函》、赵本、《集成》皆有“右”字。“内铜器中”赵本、《集成》作“于铜器内”。《玉函》、赵本“火煎”下无“之”字。“稍凝似饴状”《玉函》但作“如饴”；赵本作“当须凝如饴状”；《集成》作“稍凝如饴状”。《玉函》“勿令焦”上无“搅之”二字；下无“著”字；“欲可丸”作“俟可丸”。“并手捻作挺，令头锐、大如指，长二寸许，当热时急作，冷则鞭”句《玉函》作“捻作挺，如指许，长二寸，当热作，令头锐”；《千金翼》作“捻如指许，长二寸，当热时急作，令头锐”。《玉函》“内穀道中”上无“以”字。赵本有“疑非仲景意、已试甚良”九字。

猪胆汁方：

《玉函》无此方名；“大猪胆”上无“大”字。赵本无“猪胆汁方”四字，“大猪胆”上有“又”字。“和醋少许”句《集成》作“和少许法醋”；《千金翼》无“许”字。“穀道中”赵本、《集成》作“穀道内”。赵本、《集成》有“宿食恶物，甚效”六字；《玉函》下有“宿食恶物”四字；《千金翼》无“甚效”二字，而多“已试甚良”四字。

土瓜根方《集成》有此四字，但方阙。

246.《千金翼》、《玉函》“脉迟”上有“其”字；“微恶寒”上有“而”字。“表未解也”，《脉经》、《千金翼》、《玉函》同作“表为未解”。“微恶寒”下《脉经》、《千金翼》皆无“者”字。“可发汗”《脉经》、《玉函》皆作“可发其汗”。“宜桂枝汤”《脉经》作“属桂枝汤证”。

247.“无汗而喘者”《脉经》、《千金翼》、《玉函》同作“无汗其人必喘”。《脉经》、《玉函》“则”作“即”。“宜麻黄汤”《脉经》作“属麻黄汤证”。《玉函》“汤”下有“主之”二字。

248.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“发热”下均有“而”字。《脉经》、赵本“汗出”下有“者”字。《脉经》“不能发黄”下无“也”字。《脉经》、《千金翼》“身无汗”作“其身无有”；“剂”作“齐”。《玉函》亦作“齐”。“水浆”下《脉经》、《千金翼》、《玉函》均无“者”字。赵本、《医统》、《集成》“茵陈”下皆有“蒿”字。《脉经》作“属茵陈蒿汤”，无“主之”二字。

茵陈蒿汤方：

《玉函》无“方”字。《千金翼》“大黄二两”下无“去皮”二字。《千金翼》、赵本、《医统》、《集成》“以水一斗”下有“二升”二字。“减六升”下《集成》有“去滓”二字。赵本“分温三服”作“分三服”，无“温”字。“皂角”赵本、《集成》作“皂荚”。“尿”《千金翼》作“溺”；“汁”作“沫”；“一宿”下无“腹减”二字；“小便去”下无“也”字。

249.《脉经》、《千金翼》“其人喜忘”下无“者”字。《外台》“喜

忘”作“善忘”。《脉经》、《千金翼》无“屎”字；“鞭”作“坚”；《玉函》亦作“坚”。赵本、《集成》“其色必黑”下有“者”字。《脉经》、《千金翼》“大便反易，其色必黑，宜抵当汤下之”作“大便必黑，抵当汤主之”。《脉经》“抵当汤”上有“属”，下无“主之”。《玉函》“抵当汤”上无“宜”字；“下之”作“主之”。

250.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“腹微满”上有“其人”二字；“初头鞭，后必溏”作“头坚后溏者”。《脉经》、《千金翼》“不可攻之”作“不可下之”；并皆无“若”字。“宜大承气汤”《脉经》作“属承气汤证”。《千金翼》“承气”上无“大”字。

251.《玉函》“不大便”在“五六日”之下。《千金翼》、《玉函》“病人”作“病者”；“烦躁”作“躁烦”；“发作有时”下无“者”字；“此”字下有“为”字。

252.《脉经》、《千金翼》“病人”作“病者”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“则解”作“即解”；“又如”作“复如”。《脉经》、《千金翼》“发热者”作“发者”；“属阳明”下同无“也”字。《脉经》“脉实者”以下作“当下之，属大柴胡汤承气汤证”，另一条作“脉浮虚者，当发其汗，属桂枝汤证”。《千金翼》、《玉函》“宜下之”作“当下之”。“宜发汗”《玉函》作“当发汗”；《千金翼》作“当发其汗”。“下之与大承气汤”《千金翼》、《玉函》作“下之宜承气汤”；“汤”下无“宜桂枝汤”。

253.《千金翼》、《玉函》“此有燥屎”下同无“也”字。“宜大承气汤”《玉函》作“大承气汤主之”；《千金翼》作“宜承气汤”而无“大”字。

254.《千金翼》“病人”作“病者”；“喘冒不能卧者”作“怫郁不能卧”。《千金翼》、《玉函》“有燥屎也”作“有燥屎故也”。“宜大承气汤”句《脉经》作“属大承气汤证”；《千金翼》作“宜承气汤”；《玉函》作“大承气汤主之”。赵本“喘冒”下有“一作息”三字。

255.《千金翼》“欲呕”作“而呕”。赵本“欲呕”下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“阳明”下皆无“也”字。《千金翼》“吴茱萸汤”作“茱萸汤”，无“吴”字。“得汤反剧者，属上焦也”句不在条内而书于服法下。《玉函》“上焦”下无“也”字。

吴茱萸汤方：

《千金翼》“吴茱萸一升”下无“洗”字；《玉函》“生姜”下

无“切”字；“大枣”下无“擘”字；《外台》“洗”作“炒”；“水七升”作“水五升”。

256.“太阳病”《千金翼》作“阳明病”。《脉经》、《千金翼》“寸缓”作“寸口缓”；“关浮”作“关上小浮”；“尺弱”作“尺中弱”。《玉函》“关浮”作“关小浮”。《脉经》、《千金翼》“汗出”上有“而”字。

《千金翼》“心下痞”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》“此以”作“此为”；“如其不下者，病人……”作“若不下，其人复……”，此句《玉函》亦同。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“此转属阳明也”句同作“为转属阳明”；“大便必鞭”同作“大便即坚”；“饮水”下同有“者”字。

《脉经》“欲饮水”上无“渴”字。《脉经》、《千金翼》“少少与之”作“但与之”；“但以法救之，渴者……”作“当以法救渴……”。

257.《千金翼》“为自和也”作“为自如”，无“也”字；《玉函》亦无“也”字。赵本“自和”下有“一作如”三字。《千金翼》、赵本本条与下条并为一条。

258.《千金翼》无“阳脉实，因发其汗，出多者，亦为太过”十四字。《玉函》、赵本、《集成》“太过”下有“者”字。《千金翼》、《玉函》“为阳绝于里”句同无“为”字；“里”作“内”；“大便因鞭也”句同作“大便因坚”，而无“也”字。

259.《玉函》“浮为阳，芤为阴”作“浮则为阳，芤则为阴”。《千金翼》“胃气生热”作“胃气则生热”。

260.《千金翼》“则难”作“即坚”。《玉函》“难”作“坚”；赵本、《集成》“难”作“鞭”。“麻仁丸”《玉函》作“麻子仁圆”；《千金翼》、赵本、《集成》作“麻子仁丸”。

麻仁丸方：

《玉函》作“麻子仁圆方”。赵本作“麻子仁丸”。《集成》“麻子仁二升”作“麻仁二升”。《千金翼》“芍药、枳实”作“八两”。“大黄一斤去皮”《集成》作“大黄一升去皮”；《千金翼》、《玉函》只作“大黄一升”无“去皮”二字。“厚朴一斤炙去皮”《千金翼》、《玉函》皆无“去皮”二字；赵本、《医统》、《集成》“一斤”皆作“一尺”。《玉函》“杏仁”下无“去皮尖熬别作脂”七字。《千金翼》作“去皮尖两人者，熬别作脂”。赵本、《集成》“杏仁”作“一升”。赵本、《集成》“右六味”以下作“蜜和丸，如梧桐子大”。《千金翼》、《玉函》“丸”作“圆”。《玉

函》“以知为度”作“以和为度”。

261.《脉经》、《千金翼》、《玉函》、《外台》“发汗”均作“发其汗”。《玉函》“蒸蒸”下有“然”字。《千金翼》无“属胃也”，《脉经》“胃”字上有“于”字；“调胃承气汤主之”作“属承气汤”。

262.《脉经》、《千金翼》“腹胀满者”作“腹满者”。“与调胃承气汤”句《脉经》作“与承气汤”；《千金翼》作“承气汤主之”。

263.《脉经》、《千金翼》、《玉函》无三个“若”字。《脉经》、《玉函》、赵本、《集成》“发汗”下有“后”字。“大便因鞭者”句《玉函》作“大便坚”；《脉经》、《千金翼》作“大便因坚”。“与”字上《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆有“可”字。“愈”字上《脉经》、《千金翼》皆有“则”字。

264.《脉经》“证”作“症”；“烦躁”上有“而”字；《千金翼》“烦躁”作“而烦”。“鞭”字《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“坚”字。《脉经》、《千金翼》“四五日”作“四日”。《脉经》“以小承气汤”作“以承气汤”。“少少与”《脉经》、《千金翼》作“少与”；“不大便六七日”上同无“若”字；“虽不能食”同作“虽不大便”。赵本“能食”作“受食”，并下有“一云不大便”五字。“但初头鞭，后必溏”句《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆作“但头坚后溏”。“成鞭”《玉函》作“成坚”，《脉经》、《千金翼》作“成其坚”。“须小便利”上《脉经》、《千金翼》同有“当”字；“屎定鞭”同作“定坚”二字；《玉函》作“屎定坚”。《脉经》无“宜大承气汤”五字；《千金翼》作“宜承气汤”无“大”字。

265.《千金翼》“六七日”作“七八日”。《脉经》、《千金翼》“微热”上无“身”字；“实”字下无“也”字。《玉函》亦无“也”字。“宜大承气汤”句《脉经》作“属大柴胡汤，承气汤证”；《千金翼》作“宜承气汤”而无“大”字。

266.《脉经》、《千金翼》、《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“阳明”下皆有“病”字。《千金翼》“宜大承气汤”作“宜承气汤”；《脉经》作“属大柴胡汤”。赵本“大承气汤”下有“一云大柴胡汤”六字。

267.《千金翼》“宜大承气汤”作“宜承气汤”而无“大”字。

268.《千金翼》“宜大承气汤”作“宜承气汤”。

269.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“少阳”上皆有“与”字。《脉经》、《千金翼》“必下利”作“而利”；“脉不负”上无“其”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》、赵本、《集成》“顺”字上有“为”字。“顺”字下《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆无“也”字。

《千金翼》无“负者，失也”四字及“互相剋贼，名为负也”八字。《玉函》“失也”作“为失”。《脉经》“克贼”为“刻贼”。“名为负也”句《玉函》无“也”字；《脉经》作“为负”。“脉滑而数者”句《玉函》“脉”作“若”。《脉经》无“脉”字，《千金翼》亦无“脉”字。《脉经》、《千金翼》“宿食”下同无“也”字。《千金翼》无“当下之”三字。“宜大承气汤”句，《脉经》作“属大柴胡承气汤证”；《千金翼》作“宜承气汤”。

270.《脉经》、《千金翼》“病人”作“病者”。《脉经》、《玉函》“虽脉”作“脉虽”。《千金翼》“浮数”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“已下”作“下已”。《脉经》“合”作“今”；《千金翼》“合热”上有“而”字，下无“则”字。赵本、《集成》“善饥”作“喜饥”。“宜抵当汤”句《脉经》作“属抵当汤”；《千金翼》作“抵当汤主之”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》本条与下条合为一条。

271.《千金翼》“若”字下无“脉”字。《集成》“脉”字下无“数”字。《脉经》“不止”上无“下”字。《玉函》“协”作“挟”，《千金翼》亦作“挟”。《脉经》“协热而”作“失血”。《玉函》、赵本、《集成》“便”字上无“而”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“血”字下均无“也”字。

272.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“发”字下均有“其”字。《脉经》、《千金翼》“汗”字下无“已”字。《千金翼》“身目”上有“则”字。“以寒湿在里不解故也”句《脉经》、《千金翼》、《玉函》同作“寒湿相搏，在里不解故也”，但《玉函》“寒湿”上仍有“以”字。赵本“寒湿”下有“一作温”三字。《脉经》、《千金翼》无“以为”以下十二字。《玉函》“以为不可下也”句作“以为非瘀热而不可下”，“於”字上有“当”字。《千金翼》本条与再条（274）合为一条。

273.《脉经》、《千金翼》“橘”字下无“子色”二字；《脉经》、《玉函》“腹”作“少腹”，《千金翼》“腹”字上有“其”字。“满”字下《脉经》、《千金翼》、《玉函》均无“者”字。《千金翼》“茵陈”下无“蒿”字。《脉经》作“属茵陈蒿汤证”。

274.“伤寒身黄发热者”句《千金翼》作“伤寒其人发黄”。《玉函》、赵本同无“者”字。

梔子蘘皮汤：

《玉函》作“梔子黄蘗汤”；“梔子十五个”作“十四枚”。赵本、《集成》“梔子”上有“肥”字。《千金翼》“个”作“枚”；《医统》“十五个”作“二十五个”。《玉函》、赵本、《医统》“梔子”下皆有“擘”字。《千金翼》“甘草”下无分量；“黄蘗”作“十五分”。《玉函》“甘草”下有“炙”字；“黄蘗”作“二两十六铢”；“味”字下有“咬咀”二字。《千金翼》“煮取一升半”作“煮取二升”。

275.赵本“黄”字上无“发”字。《千金翼》“身必发黄”作“身体必黄”。《玉函》“麻黄”上有“宜”字。

麻黄连轺赤小豆汤方：

《千金翼》“麻黄”作“一两”；《玉函》无“去节”二字。《千金翼》“连轺”作“连翘”亦作“一两”无“连翘根也”四字；《玉函》亦无此四字；赵本、《集成》作“连翘根是”。《千金翼》、《玉函》“杏仁”作“三十枚”。《千金翼》“生梓白皮”作“一斤”；“生姜”上有“一方”二字。赵本、《集成》“梓白皮”作“切一升”。《玉函》“甘草”作“一两”。赵本、《医统》、《集成》“大枣”有“擘”字；“已上八味”作“右八味”。《玉函》也作“右八味”。《千金翼》“八味”作“七味”；无“潦”字；“再沸”作“一二沸”。《玉函》亦作“一二沸”。赵本、《集成》有“去滓”二字。《玉函》“滓”作“渣”。《千金翼》、《玉函》“分温三服”作“温服一升”，无“半日服尽”。《千金方》“轺”亦作“翘”；“潦”作“劳”。

276.《千金翼》、《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“之”的下皆有“为”字。

277.《玉函》“闻”字上无“所”字。《千金翼》、《玉函》“烦”字下同无“者”字。《玉函》“则”作“即”。

278.《千金翼》“伤寒”下有“病”字；“头痛”下有“而”字；“发热”下无“者”字；“属”字上有“此为”二字；“此属胃”作“为属胃”；“则愈”作“即愈”。《玉函》亦作“即愈”。《千金翼》“不和”上无“胃”字，下无“则”字。赵本“烦”字上无“则”字；“悸”字下有“一云躁”三字。

279.《千金翼》、《玉函》“太阳”上无“本”字。《千金翼》“少阳”下无“者”字。“鞭”字《千金翼》、《玉函》同作“坚”；“不能食”下皆有“饮”字。《千金翼》“尚未”作“而未”；“脉”字上《千金翼》、《玉函》同有“其”字；“紧”字下同无“者”字。《千金翼》“与”字上有“可”字。《千金翼》、《玉函》本条与下条（280）合为一条。

280.《集成》“柴胡”下有“汤”字。

281.《千金翼》无“合病”二字。“但欲眠睡”句《千金翼》、《玉函》作“但欲寐”。

282.《千金翼》、《玉函》“躁烦”下同无“者”字。《玉函》“入阴”下无“故”字。

283.《千金翼》两“邪”字上均有“其”字。

284.《玉函》此条文，在“辨太阳病形证治第三”之中；“欲已也”句作“为欲已”。《千金翼》“脉小”下无“者”字；“欲已”下无“也”字。

285.《千金翼》、《玉函》“至辰上”作“尽辰”。

286.《千金翼》“吐”上无“而”字。《脉经》、《千金翼》“自利益甚”作“下之益甚”；无“若下之”三字；“胸上”无“必”字。《脉经》“时腹”作“腹时”。“结鞭”，《玉函》作“痞坚”；《脉经》作“结坚”；《千金翼》作“坚结”。

287.《千金翼》“长”下无“者”字。

288.《千金翼》、《玉函》“至丑上”作“尽丑”。

289.《千金翼》“浮”下无“者”字。“可发”下，《脉经》、《千金翼》、《玉函》皆有“其”字。《脉经》“宜”作“属”；“汤”下有“证”字。《千金翼》无“宜桂枝汤”四字。《玉函》将此条列在287条之前。

290.《脉经》、《千金翼》“其藏”上同无“以”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“四逆辈”上皆无“服”字。

291.《千金翼》“温”上无“自”字；“系”上有“是为”二字；“当发”下无“身”字；“若小便自利者”作“小便自利者”；“虽暴烦，下利日十余行”作“虽烦，暴利十余行”。“以脾家实”上《千金翼》有“所以自止者”五字；《玉函》有“所以然者”四字。《千金翼》“脾家实”上无“以”字；《玉函》“以”作“此”。

292.《脉经》、《玉函》首无“本”字。《脉经》、《千金翼》“因”下无“而”字；“时痛”下无“者”字；“属太阴”上有“为”字，下无“也”字。《玉函》、赵本、《集成》“而”作“尔”。《脉经》“桂枝加芍药汤主之”作“属桂枝加芍药汤”。

293.“大实痛者”《千金翼》作“其实痛”，而无“者”字；《脉经》亦无此“者”字。《脉经》“桂枝加大黄汤主之”作“属桂枝加大黄汤”。《千金翼》“加大黄”上无“桂枝”二字。《脉经》、《千金翼》、赵本、《集

成》皆将293与292条合为一条。

桂枝加芍药汤方：

《玉函》方名作“桂枝倍加芍药汤方”。《玉函》、赵本、《集成》方下均有药味、剂量、煎服法等详细记载。

桂枝加大黄汤方：

《玉函》“桂枝”下无“去皮”二字；“生姜”下无“切”字；“大枣”下无“擘”字；“大黄”作“三两”。赵本、《集成》“大黄一两”作“大黄二两”。《千金翼》只载“加大黄汤”作“大黄二两”，“右于前方中加此大黄二两即是”。《玉函》“味”下有“~~咬~~咀”二字，无“日三服”三字。

294.《千金翼》“太阴为病”作“人无阳证”；“减之”上无“宜”字；“其人”上无“以”字。《玉函》“其人”上无“以”字；“故也”下有“下利，先煎芍药三沸”八字。赵本亦有“下利者，先煎芍药三沸”九小字。

295.《千金翼》、《玉函》“欲寐”下无“也”字。《医统》“寐”作“寢”。

296.《千金翼》“欲吐不吐，心烦”句，作“欲吐而不烦”；“属少阴”下无“也”字；“小便”上无“若”字，下无“色”字。《玉函》“若”下有“其人”二字；“少阴病形”上有“为”字；“小便白者”作“所以然者”。《千金翼》“小便白者”上有“其人”二字；“下焦”上无“以”字；“虚”下无“有”字；“制水”作“制洩”，《玉函》亦作“制洩”。《千金翼》、《玉函》“白也”下无“令色”二字。《千金翼》将本条与下条合为一条。

297.《千金翼》“病人”作“夫病其”。《千金翼》、《玉函》“反汗出”上有“而”字，下无“者”字。《玉函》“亡阳”上有“为”字，下无“也”字。《千金翼》“亡阳也”作“为阳”；“属少阴”上无“此”字。

298.《脉经》、《千金翼》“谵语”下无“者”字；“被火”上有“是为”二字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“以”作“为”。

299.《千金翼》“病”下无“为”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“汗”上有“其”字。

300.《脉经》“脉微”下有“一作濡而微弱”六小字；“汗”上有“其”字，《千金翼》亦有此“其”字。《脉经》“亡阳”作“无阳”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“尺脉”皆作“尺中”。

301.《千金翼》“紧”下有“者”字；“下利”上无“自”字；“脉暴微”上有“其”字，《玉函》亦有此“其”字。《千金翼》“脉紧反去”上有“其”字，下无“者”字。《玉函》“去”上无“反”字，下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“为欲解”上无“此”字，下无“也”字。

302.《脉经》、《千金翼》“若利”下无“自”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“蜷”下皆无“卧”字。

303.《千金翼》“衣被”下无“者”字；“可治”上有“不”字。《脉经》“时”作“时时”。

304.《千金翼》“脉”上有“其”字。《千金翼》、《玉函》“阴浮”下无“者”字。

305.《千金翼》、《玉函》“至寅上”作“尽寅”。

306.《脉经》、《千金翼》“吐利”上有“其人”二字；“逆”下无“冷”字；“发热”下无“者”字。《千金翼》“脉不至”作“脉不足”。赵本“脉不至者”下有“至一作足”四小字。《脉经》“灸”下有“其”字。《玉函》将此条列于下条之后。

307.《千金翼》“一身”上有“而”字；“尽热”下无“者”字；“热在”上无“以”字；“血”下无“也”字。

308.《千金翼》“强”上无“而”字；“血”上无“其”字；“目出”上无“或从”二字。《脉经》、赵本、《集成》“目出”下有“者”字。《脉经》、《千金翼》“名”作“为”。

309.《脉经》、《千金翼》“蜷”上无“身”字；“逆”下无“冷”字。

310.《脉经》、《千金翼》“吐利”上有“其人”二字。《玉函》作“躁烦”为“烦躁”。《脉经》、《千金翼》“躁烦四逆”作“躁逆”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》将此条列于下条之后。

311.《脉经》、《千金翼》“眩”上无“头”字。

312.《脉经》、《千金翼》“蜷”上无“身”字；“脉”上有“其”字；“不烦”上有“其人”二字。赵本“死”下有“一作吐利而烦躁者死”九小字。

313.“息高者”上，《脉经》有“其人”二字；《千金翼》有“其”字。

314.《脉经》、《玉函》“五六日”上无“至”字。

315.《千金翼》“脉”下有“反”字。《千金翼》、赵本“麻黄附子细辛汤”作“麻黄细辛附子汤”。

麻黄附子细辛汤方：

《玉函》“麻黄”下无“去节”二字；“附子破”下有“作”字。《千金翼》“水一斗”作“水二斗”；“减二升”作“减一升”。《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“内”下有“诸”字。《千金翼》、《玉函》无“日三服”三字。

316.《脉经》、《千金翼》、赵本、《医统》“无里证”皆作“无证”。“故发微汗也”，《脉经》作“故微发汗也”；《千金翼》、《玉函》作“故微发汗”。

麻黄附子甘草汤方：

《玉函》“麻黄”下无“去节”二字；“附子炮”作“附子泡”，并有“破八片”三字。《千金翼》、《玉函》“一两沸”作“一二沸”；“煮取三升”作“煮取二升半”；“温服一升”作“温服八合”；无“日三服”三字。《千金翼》“炮”作“泡”。赵本、《集成》“去皮”下有“破八片”三字。

317.《玉函》“以上”作“已上”。《千金翼》、《外台》“卧”下有“者”字。

黄连阿胶汤方：

赵本、《集成》“黄芩一两”作“黄芩二两”。“阿胶”，《千金翼》作“三挺”，《外台》作“三片”；赵本、《集成》下有“一云三挺”四小字。赵本、《集成》“水五升”作“水六升”。《千金翼》“三物”作“三味”；“烊尽”下无“小冷”二字。

318.《脉经》无“附子汤主之”五字。

附子汤方：

赵本、《集成》“附子二枚破八片去皮”作“附子二枚炮去皮破八片”。《玉函》“附子”下有“炮”字，无“破八片去皮”五字；“味”下有“^咬咀”二字。《千金翼》“温服一升，日三服”作“分温三服”。

319.《玉函》“脉沉”下有“一作微”三字。

320.《千金翼》、《玉函》“脓血”下无“者”字。

桃花汤方：

《千金翼》“赤石脂一斤”下作“一半完，一半末”；“煮米令熟”作“煮米熟汤成”；“温服”作“温取”；“方寸匕”上有“一”字；“一服愈”作“一服止”。赵本、《医统》、《集成》“粳米一斤”作“粳米一升”。

321.《千金翼》“小便”下无“不利”二字；“便脓血”上有“而”字。《玉函》“便脓血”上有“而”字，下无“者”字。《千金翼》“桃花汤”上有“以”字。

322.《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“下痢”作“下利”。

323.《玉函》“手足”上有“而”字。《玉函》、赵本、《集成》“厥冷”作“逆冷”。《千金翼》“厥”下无“冷”字。

324.《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“痢”作“利”。《千金翼》、《玉函》、赵本“心烦”下无“者”字。

猪肤汤方：

《玉函》“右”下无“一味”二字。赵本、《医统》、《集成》“相得”上有“令”字。

325.《千金翼》、赵本“不差”下无“者”字。

甘草汤方：

《千金翼》“甘草”下无“二两”二字；“日二服”作“日再服”。《外台》“日二服”作“日三服”。

桔梗汤方：

《千金翼》“桔梗”下“一两”作“一大枚”。《外台》“甘草二两”作“甘草三两”。赵本、《集成》“分温”作“温分”。

326.《千金翼》“不出”下无“者”字。

苦酒汤方：

赵本、《集成》“枣核”下无“大”字。《玉函》“十四枚”下有“内苦酒中”四字；“鸡子一枚去黄”，下“内上苦酒著鸡子壳中”作“内苦酒于壳中”，《千金翼》作“内好上苦酒于壳中”。《玉函》“右”下无“二味，内半夏，著苦酒中”九字；“三沸”上无“令”字；“少少”作“细”；“更作”下无“三剂”二字。《千金翼》“三剂”下有“愈”字。

327.《外台》“咽中”作“咽喉”。《千金翼》无“主之”二字。

半夏散及汤方：

《玉函》“半夏”下无“洗”字；“桂枝”下无“去皮”二字；“甘草”下无“以上”二字。赵本、《集成》“甘草”下无“以上各等分”五字。《玉函》、赵本、《集成》“已上”作“右”字。赵本、《集成》“三味”下有“等分”二字。《玉函》“捣筛”下无“已”字；“散服”下无“者”字。《千金翼》“各别捣筛已”作“各异捣”。《玉函》“两方寸匕”作“一二方寸匕”。赵本、《集成》“少少咽之”下有“半夏有毒，不当散服”八字。

328.经文部分以上诸本皆同。

白通汤方：

赵本、《集成》“附子一枚生”下无“用”字。《玉函》“破”下无“八片”二字。

329.《千金翼》、《玉函》“脉微”下皆无“者”字；“与”作“服”。《千金翼》“干”下无“呕”字；“服汤”以下十一字列在方后。《脉经》本条作“少阴病下利不止，厥逆无脉、干呕烦，服汤药，其脉暴出者死，微细者生”。

白通加猪胆汁方：

赵本“胆”下无“汁”字，而有“汤”字。《玉函》、《医统》、《集成》“汁”下均有“汤”字。《玉函》“附子”下无“去皮破八片”五字。《玉函》、赵本、《集成》“已上三味”作“右三味”。《玉函》“煮”下无“取”字；“胆汁人尿”作“人尿胆汁”；“和”下无“令”字；“无胆”上无“若”字；“亦可”下无“用”字。《千金翼》作“右二味，内前汤中，和令相得，温分再服。若无胆，亦可用。服汤，脉暴出者死，微续者生”。

330.《千金翼》、《玉函》“自下利者”作“而利”。“或小便利”，《玉函》作“或小便自利”；《千金翼》作“或小便不利”。《千金翼》“或呕”下无“者”字。《千金》、《千金翼》“真武汤”作“玄武汤”。

真武汤方：

《千金》、《千金翼》均作“玄武汤”。《玉函》“茯苓、芍药”下皆无“三两”二字；“生姜”下无“切”字，有“各”字；“附子”下无“去皮破八片”五字。《外台》“白术二两”作“白术三两”；“右五味”下有“切”字。

《千金翼》无“日三服”三字。《玉函》、赵本、《集成》“三服”下无“后加減法”四字；“五味”下有“子”字。赵本、《集成》“细辛”下有“一两”二字；“干姜”下无“各”字；“生姜足前”下“成半斤”作“为半斤”。《千金翼》“半斤”下有“利不止，便脓血者，宜桃花汤”十一字。《医统》“五味”下亦有“子”字。

331. 《千金翼》“恶寒”上无“不”字；“面赤”下无“色”字。赵本、《集成》“面赤色”作“面色赤”。《玉函》、《千金翼》“脉不出”上有“而”字，下无“者”字。

通脉四逆汤方：

《玉函》“附子”下无“八片”二字；“强人”下无“可”字。《千金翼》“面”下无“色”字；“葱”下有“白”字；“乃”下有“加減”二字。《玉函》无“去葱”、“去芍药”、“去桔梗”等字；“桔梗”下“一两”作“二两”。赵本、《集成》“人参二两”下有“病皆与方相应者，乃服之”十字。

332. 《千金翼》“下重”下无“者”字。

四逆散方：

《玉函》“枳实”下无“破、水渍炙干”五字，而有“炙各十分”四字。《千金翼》“各十分”三字载于药下。《玉函》“四味”下无“各十分”三字；“白饮”下无“和”字。“捣筛”，《千金翼》作“捣为散”；《玉函》作“为散”。“并主下痢”《千金翼》作“兼主利”；《玉函》作“并主久痢”；赵本、《医统》、《集成》“痢”作“利”。《千金翼》“加桂”下无“枝”字。《玉函》“腹”下无“中”字。《千金翼》、《玉函》“炮”下无“令坼”二字；“取三升”上无“煮”字。

333. 《千金翼》“下利”作“不利”；“眠”下无“者”字。赵本有“猪苓汤方”。

334. 《千金翼》“咽干”下无“者”字；“承气汤”上无“大”字。《脉

经》“宜大承气汤”作“属承气汤”。

335.《脉经》、《玉函》“自利”作“下利”。《千金翼》“利”上无“自”字。《脉经》、《千金翼》“色纯青”作“色青者”；“急下”作“可下”，赵本亦作“可下”。“宜大承气汤”，《脉经》作“属大柴胡汤承气汤证”；《千金翼》作“宜承气汤”。赵本“汤”下有“一法用大柴胡汤”七字。

336.《脉经》、《千金》、《千金翼》“腹胀”作“腹满”。“宜大承气汤”，《脉经》作“属承气汤证”；《千金翼》作“宜承气汤”。

337.《千金翼》“脉”上有“其”字；“急”作“当”。《脉经》“急”下有“当”字。

338.《脉经》、《千金翼》“欲食”上有“其人”二字；“入”下无“口”字。《玉函》“则吐”作“即吐”；“心中温温”作“心下温温”。《脉经》、《千金翼》“弦迟”下无“者”字；“当吐之”作“当遂吐之”。《千金翼》、《玉函》“不可吐”下无“也”字。赵本、《集成》“急温之”作“当温之”。

339.《脉经》、《千金翼》“涩”下有“者”字。“呕而汗出”，《脉经》作“即呕汗出”；《千金翼》作“即呕汗者”。《脉经》、《千金翼》“反少”下无“者”字。“灸之”下，《脉经》有“一云灸厥阴可五七壮”九字；《千金翼》有“一云灸厥阴五十壮”八字；《玉函》有“脉经云灸厥阴五十壮”九字；赵本有“脉经云灸厥阴可五十壮”十字。

340.《脉经》、《千金翼》“气上撞”下无“心”字。《玉函》“饥”下无“而”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“食则”上有“甚者”二字；《脉经》、《千金翼》无“食”字。《脉经》“吐蚘”作“欲吐”。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“利不止”作“不肯止”。

341.《千金翼》、《玉函》“脉”上有“其”字。

342.“从寅至卯上”，《千金翼》、《玉函》作“从丑尽卯”；赵本、《医统》、《集成》作“从丑至卯上”。

343.《玉函》“愈”上有“即”字。《脉经》、《千金翼》“少少与之愈”作“与水饮之即愈”。

344.以上诸本皆同。

345.《千金翼》“必”下无“自”字。

346.《千金翼》“而”下有“下”字；“厥利”上无“凡”字，下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“能食”下无“者”字。赵本“除中”下有“一云消中”四字。《千金翼》“食以索饼”作“食之黍饼”。《千金翼》、赵本、

《集成》第一个“后三日脉之”中无“三”字。《千金翼》、《玉函》“续在”下无“者”字。《玉函》无“所以然者……夜半愈”三十八字。“而脉数”，《千金翼》作“数”；《玉函》作“而数”。《千金翼》、《玉函》“不罢”下无“者”字；“痈脓”下无“也”字。

347.“今与”，《千金翼》作“与”，而无“今”字；《玉函》作“而与”。《千金翼》“腹中”下无“应”字。《千金翼》、《玉函》“此名”作“此为”。

348.《千金翼》“先厥”下无“后”字；“咽中痛者”作“咽中强痛”；“必便脓血”上无“若不止”三字。《玉函》“若不止”作“不止者”。《千金翼》“便”上无“必”字。《集成》“必便脓血”下无“便脓血”三字。

349.《脉经》、《千金翼》、赵本、《集成》“四五日”下无“而”字。《脉经》、《千金翼》“前热者后必厥”作“前厥者后必热”。《千金翼》“厥深”、“厥微”下皆无“者”字。“而反发汗者”句，《脉经》、《玉函》作“而反发其汗”；《千金翼》作“而发其汗者”。《千金翼》“口伤”上无“必”字。

350.《千金翼》“不过”上无“终”字。《千金翼》、《玉函》将本条列于下条之后。

351.《千金翼》“逆”下无“冷”字；“是”下无“也”字。赵本、《集成》“逆冷”下有“者”字。

352.《千金翼》“此为藏厥，非为蛔厥也”作“此为藏寒，蛔上入其膈”；“安”上无“暂”字。《玉函》、赵本“非”下无“为”字。《玉函》“令”作“今”。赵本、《集成》“时烦”下有“者”字；“膈”上有“其”字。《千金翼》“膈”上亦有“其”字；“蚘闻食臭”下有“必”字。

《千金翼》、赵本“当”作“常”。《玉函》、《医统》“丸”作“圆”。《玉函》无“又主久利方”五字。《千金翼》“利”下无“方”字。

乌梅丸方：

《玉函》“丸”作“圆”。赵本、《集成》“乌梅”下“三百个”作“三百枚”；“黄连”下“一斤”作“十六两”；“附子”下有“去皮”二字；“蜀椒”下“去子”作“出汗”；“桂枝”下有“去皮”二字。《千金翼》“十味”上有“一”字；“异捣”下无“筛”字。《千金翼》、赵本、《集成》“五升”作“五斗”。《千金翼》无“饭熟”二字。《玉函》“饭熟”下有“取”字。

《千金翼》“和”下有“诸”字；“臼中”上无“内”字；“杵”下无“二”字。

《玉函》“千”下无“下”字。《千金翼》“稍”作“少少”。《玉函》、《医统》“丸”作“圆”。《玉函》“臭食”作“食臭”。《千金翼》黄连作“十六两”。（“黄柏”下有“一方用麦柏”五小字；“和药”作“盘中搅”。）

353.《千金翼》、赵本、《集成》“厥微”作“微厥”；“默默”作“嘿嘿”；《玉函》亦作“嘿嘿”。《千金翼》“指头”作“稍头”。赵本“指”下有“一作稍”三小字。《千金翼》“热除”上无“此”字；“得食”上无“欲”字；“烦满”下无“者”字；“便血”下有“稍头，一作指头”六小字。

354.《千金翼》“小腹”作“少腹”；“痛”下无“者”字。

355.《千金翼》“复”下有“发”字。赵本、《集成》“热多”下有“者”字。《千金翼》“七日”上有“六”字；“不除”上无“热”字；下无“者”字；《玉函》亦无此“者”字。《玉函》、赵本、《集成》“必便”上无“其后”二字。《玉函》“必便”作“必清”。

356.《千金翼》、《玉函》“进”下无“也”字。

357.《脉经》、《玉函》“脉微”上有“其”字。《千金翼》“脉微”作“其脉数”。《脉经》、《千金翼》“厥”下无“冷”字。《脉经》“灸”下有“其”字。《千金翼》“阴”上无“灸厥”二字。

358.《脉经》、《千金翼》“伤寒”下无“发热”二字。《脉经》“不得卧”作“不能卧”。

359.《脉经》、《千金翼》“至”下无“甚”字。《玉函》无此条文。

360.《玉函》“不利”作“不便利”；“便发热”作“忽发热”。《脉经》“伤寒”下有“厥逆”二字；“其人”上有“生”字；“汗出”下有“利”字；“有阴无阳”上有“但”字。

361.《千金翼》“不可下”下有“之”字。“此为亡血，下之死”句，《脉经》、《千金翼》作“下之亡血死”。赵本“亡血”上无“为”字。

362.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“发热”上有“伤寒”二字。

363.《脉经》、赵本“逆”下无“者”字。《脉经》“可灸之”下有“为可灸少阴厥阴主四逆”十字。

364.《千金翼》“里有热也”作“其表有热”。赵本“热”下无“也”字。

365.《千金翼》、《玉函》“脉细欲绝者”作“脉为之细绝”。《玉函》将本条与下条合为一条。

当归四逆汤方：

《千金翼》“桂枝”作“桂心”。赵本、《集成》“桂枝”下有“去皮”二字。《玉函》“当归、桂枝”下均无“三两”二字；“芍药”下有“各”字，并皆作“二两”；“细辛”下“三两”作“一两”；“大枣”下“二十个”作“二十五枚”；“甘草”下无“二两”二字；“通草”下有“各”字。赵本、《集成》“大枣”下“二十五个”作“二十五枚”，并下有“一法十二枚”五小字。《玉函》“味”下有“㕮咀”二字。

366. 《千金翼》“有”上无“内”字，下无“久”字。《千金翼》、《玉函》“寒”下无“者”字；“当归”上无“宜”字。赵本、《集成》“汤”下无“主之”二字。

四逆加吴茱萸生姜汤方：

《玉函》、赵本、《集成》方名首有“当归”二字。《医统》“当归”下“三两”作“二两”。《玉函》“甘草、通草”皆作“三两”。《集成》“茱萸”上无“吴”字。《千金翼》、《玉函》“吴茱萸”下“二升”作“二两”。《千金翼》“生姜”下“半斤”作“八两”。《玉函》“大枣”下无“擘”字；“生姜”下无“切”字；“味”下有“㕮咀”二字；“水”与“酒”皆作“四升”；“煮”上无“和”字；“取五升”作“取三升”；“温分五服”作“温服一升、日三”；无“一方水酒各四升”七字。《千金翼》作“右前方中加此二味，以水四升、清酒四升和，煮取三升，去滓，分温四服”。

367. 《千金翼》“拘急”上无“内”字；“又”作“若”；《脉经》无“又”字。《千金翼》“厥”下无“逆”字。《脉经》、《千金翼》“恶寒”下无“者”字。《脉经》“四逆汤主之”作“属四逆汤”。

368. 《千金翼》、《玉函》“大汗”下有“出”字。《千金翼》“若大”作“若火”。《脉经》“大下”下无“利”字。《千金翼》“厥”下无“冷”字。《脉经》“四逆汤主之”作“属四逆汤证”。

369. 《脉经》、《千金翼》、《玉函》“病人”作“病者”。《脉经》“紧”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》、赵本、《医统》、《集成》“心中”作“心下”。《脉经》、《千金翼》“能食”下无“者”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“吐之”上无“须”字。《脉经》无“宜瓜蒂散”四字。《医统》“当须”作“尚须”。

370.《千金翼》、赵本“悸”下无“者”字。《千金翼》“宜先治水”作“先治其水”。《千金翼》、《玉函》“当服”作“当与”。《千金翼》“水渍入胃”作“其水入胃”；“必作利也”作“必利”。

371.《千金翼》“大下”上有“其人”二字；“脉沉”上无“寸”字。《千金翼》、《玉函》“沉”下无“而”字。赵本、《集成》“咽喉”作“喉咽”。《千金翼》“不止”下无“者”字。《脉经》“大下”上有“其人”二字；“脉”上无“寸”字；“迟”上无“而”字；“不止”下无“者”字；“麻黄”上有“属”字；“汤”下无“主之”二字。

麻黄升麻汤方：

《千金翼》、《玉函》“升麻、当归”同作“一两六铢”；“天门冬”同作“麦门冬”。赵本、《集成》“知母”下有“十八铢”；“黄芩”下有“十八铢”三字；“萎蕤”下无“各”字，并有“一作菖蒲”四字；“芍药”、“石膏”、“白术”、“干姜”、“天门冬”、“茯苓”下均有“六铢”二字；“桂枝”下有“六铢、去皮”四字；“甘草”下无“各”字。《千金翼》“右”下有“一”字。《玉函》“味”下有“~~咬~~咀”二字；“一两沸”作“一二沸”。《千金翼》“两沸”上无“一”字。“相去如炊三斗米顷，令尽”句，《千金翼》作“一炊间、当”四字；《玉函》作“一饭间，当”四字。

372.《医统》“趣”作“趋”。《千金翼》、《玉函》“此”作“为”。《千金翼》“少腹”下无“者”字；“自利”下无“也”字。

373.《千金翼》、《玉函》“吐”下无“下”字。《千金翼》“寒格”上有“而”字。《脉经》“逆吐下”作“遂吐”，并有“一本作更逆吐下”七小字。《千金翼》“逆吐”下无“下”字。“若食入口即吐”句，《脉经》、《千金翼》作“食入即出”；《玉函》作“食入即出者”。《脉经》“干姜”上有“属”字；“汤”下无“主之”二字。《玉函》、赵本、《集成》“黄连黄芩”作“黄芩黄连”。《玉函》“汤”上无“人参”二字。

干姜黄连黄芩人参汤方：

《玉函》、赵本、《集成》作“干姜黄芩黄连人参汤方”。

374.《千金翼》“而渴”作“其人渴”。《千金翼》、《玉函》“自

愈”上无“今”字。

375.《千金翼》“有微热”作“若发微热”。《千金翼》、《玉函》“汗出”下有“者”字，“自愈”上无“今”字。《千金翼》“复紧”上有“脉”字。赵本“解”下有“一云设脉浮复紧”七小字。

376.《脉经》、《千金翼》“厥”下无“冷”字；“无脉”下无“者”字；“不温”下无“若脉不还”四字。《玉函》“若”作“而”字。《脉经》、《千金翼》、赵本均将本条与下条合为一条。

377.《千金翼》“为顺”下无“也”字。

378.《千金翼》“脉”上无“寸”字；“自涩”下无“者”字；“必清”上有“其人”二字。

379.《脉经》、《千金翼》、《玉函》“不可攻”下皆有“其”字。

380.《千金翼》、《玉函》“下重”下无“也”字。《千金翼》“脉大”上有“其”字。《医统》“发热”作“发汗”。

381.《千金翼》、《玉函》“清谷”下无“者”字。《千金翼》“病人”作“其人”，“微厥”上无“必”字。

382.《千金翼》、《玉函》“脉”下有“反”字。《千金翼》“有热”上无“以”字。

383.《玉函》“脉绝”上有“其”字。《千金翼》、《玉函》“厥”下无“冷”字。《千金翼》“不还”上无“脉”字。《玉函》“脉不还者死”作“不还温者死”。

384.《脉经》、《千金翼》“脉”上有“其人”二字。

385.《千金翼》、《玉函》“下重”下无“者”字。

白头翁汤方：

《玉函》“白头翁”下无“二两”字；赵本、《集成》“黄柏”、“黄连”下均有“三两”二字；“秦皮”下无“各”字。《千金翼》“不愈，更服一升”作“不差，更服”。

387.《脉经》、《千金翼》“腹”下无“胀”字。《脉经》、《千金翼》、《玉函》“疼痛”下无“者”字。《玉函》、赵本、《医统》、《集成》“温里”与“攻表”下皆有“宜”字。《脉经》无“乃攻其表，温里”“攻表

桂枝汤”十一字；“四逆汤”上有“宜”字。《千金翼》将本条载于下条之后。

388.《玉函》“饮水”下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“以有热”作“为有热”。“有热”下，《玉函》无“故”字；《千金翼》无“故也”二字。

389.《千金翼》“下利”下有“而”字；“谗语”下无“者”字；“有燥屎”上有“为”字，下无“也”字；“小承气汤”上无“宜”字，下有“主之”二字。

390.《千金翼》“按之”作“按其”。《千金翼》、《玉函》“梌子”上无“宜”字；“汤”下有“主之”二字。

391.《千金翼》、《玉函》“痈脓”下无“者”字。

392.《千金翼》“厥”下无“者”字。

393.《千金翼》、《玉函》“头痛”上有“而复”二字，下无“者”字。

394.《千金翼》“发热”下无“者”字。《千金翼》、《玉函》将本条列于392条之前。

395.《千金翼》“大吐”下无“大”字。《脉经》、《千金翼》、赵本“汗”下无“出”字；“其人”上无“以”字。《千金翼》“与之水”作“与其水”。《医统》“因得哕”作“固得哕”。

396.《千金翼》“满”上无“腹”字，下有“者”字。《玉函》“视”作“问”。《玉函》、赵本、《集成》“则愈”作“即愈”。

397.《千金翼》“何”下有“也”字；“名曰”作“此为”。赵本、《集成》“名曰”作“此名”。

398.《千金翼》“病”下有“者”字；“身”下有“体”字；“疼”下有“痛”字。“吐利”上《玉函》有“不复”二字；《千金翼》有“而复”二字。“吐利”下《玉函》、《千金翼》同无“者”字；“此属”同作“当属”；“此名”同作“当为”。赵本、《集成》“自吐下”上有“霍乱”二字。

《千金翼》、《玉函》“吐下”上无“自”字；《千金翼》、《玉函》“利止”上同无“又”字。

399.《千金翼》、《玉函》“涩”下同无“者”字；“必利”同作“当利”；“呕”上同有“素”字；“治”上同无“可”字，下同无“也”字。“欲似大便”句，《玉函》作“若其人似欲大便”；《千金翼》作“若其人，即欲大便”。《千金翼》、《玉函》“而反”作“但反”。《玉函》“仍不利”上有“而”字，下无“者”字。《千金翼》“仍”作“而”。赵本属上有“此”字。“此属阳明也”句《千金翼》、《玉函》同作“是为属阳

明”。“便必鞭”句，《玉函》作“便必坚”；《千金翼》作“必坚”二字；“十三日”作“十二日”；“尽”字作“竟”。本节赵本与下条（400）合为一条。

400.“当便鞭”句，《玉函》作“便当坚”；《千金翼》作“当坚”二字。“鞭则”《玉函》作“坚则”；《千金翼》作一“坚”字，而无“则”字。“一经”上《千金翼》无“过”字。“不愈者”句，《千金翼》、《玉函》同作“若不愈”。《千金翼》本节与下条（401条）合为一条。

401.“亡血也”句，《千金翼》作“必亡血”。赵本“脉微”下有“一作”。《玉函》方名作“人参四逆汤方”。

人参四逆汤方：

赵本药物、剂量、煎服法均有详细记载。

402.《千金翼》“头痛”上有“而”字；“身”下有“体”字。《千金翼》、《玉函》“饮水”下无“者”字；“理中丸”作“理中汤”。《医统》“丸”作“圆”。

理中丸方：

赵本、《集成》所列方中，药物皆无性味，且干姜列甘草之前。《玉函》作“理中圆及汤方”；“干姜”下无“已上”二字。《医统》作“理中圆方”。《千金翼》先列汤后列丸；“右四味”下作“以水八升……勿发揭衣被，一方蜜和丸”。“蜜和丸”句，《玉函》作“为末蜜和圆”。赵本、《集成》“丸”字上有“为”字；“如鸡黄大”句作“如鸡子黄许大”。《玉函》“一丸”作“一圆”。“日三四，夜二服”句，《玉函》作“日三服，夜二服”，《千金翼》作“日三夜二”。《玉函》“三四丸”作“三四圆”。《千金翼》无“汤法”二字。赵本、《集成》“日三服”下无“加减法”三字。《千金翼》“脐”作“齐”；三个“足前成四两半”皆作“至四两半”；“服汤后”作“服药后”；“如食顷”作“如食须”；“一升”下无“许”字；“微自温”有“暖”字。赵本方名下有“下有作汤加减法”小七字。

403.《千金翼》“痛不休”上有“体”字，下无“者”字。

404.《千金翼》“手足厥”下无“冷者”二字。本书此条与下条405合为

一条。

405.《千金翼》、《玉函》“内寒”同作“里寒”。《千金翼》“欲绝”下无“者”字。

406.《千金翼》无“拘急”二字；“欲绝”下无“者”字。《千金翼》“猪胆”下无“汁”字。《千金方》、《外台秘要》作“吐下已断”，并用“通脉四逆汤”而不加“猪胆汁”。

通脉四逆加猪胆汁汤方：

《玉函》、赵本、《集成》药物、剂量、煎服法均有详细记载。

407.《玉函》本条列在414条之后。《玉函》“吐利”作“吐下”。《集成》“发汗”下有“后”字。《千金翼》、《玉函》“脉平”上同有“其人”二字；“小烦”上同有“而”字。《千金翼》“小烦”下无“者”字。《千金翼》、《玉函》“以”同作“此”。

408.《千金翼》“阴阳易”作“阴易”而无“阳”字；无“其人”二字。赵本“眼中生花”下有“花一作眇”四小字；《玉函》“生花”下有“眼胞赤”三字；“拘急”下无“者”字。《千金翼》有“痴胞赤”三字。赵本、《集成》“裯”作“裯”。

烧裯散方：

《千金翼》“中裯”作“里裯”；“烧”字上无“剪”字。赵本、《集成》“以水和服”上有“右一味”三字；“以水和服”作“水服”；“剪烧灰”作“取烧作灰”。《千金翼》“日三”下无“服”字；无“妇人病”以下九字。赵本、《集成》“妇人”上无“右取”二字；“中裯”作“中裯”；“则愈”作“此为愈矣”；“男子裯当烧灰”作“男子裯烧服”。

409.赵本、《集成》“主之”后无“若有宿食者，加大黄如博碁子大五六枚”十六字。

枳实栀子豉汤方：

《集成》作“枳实栀子汤方”无“豉”字。《集成》、赵本“十四枚”作“十四个”。《玉函》“右”下无“三味”二字。《千金翼》“清浆水”作“酢浆”；“空煮”作“先煎”。《玉函》“空煮取四升”作“空煎减三升”。《千金翼》“内枳实栀子”作“次内二味”。《千金翼》、《玉函》“下豉”同作“内豉”。《千金翼》“煮”上无“更”字。《千金翼》、《玉函》“温分”作“分温”。《千金翼》无“复令微似汗”五字，有“若有宿食”以下十八字；《玉函》此五字作“取汗出”三字。《玉函》方后注下有“若有宿食，加大黄如博碁子大五六枚”十四字。《千金翼》亦同。《玉函》“内大黄”作“加大黄”，无“服之愈”三字。赵本、《集成》方后注有“若有宿食者”以下十九字，但于经文下无“若有宿食者……五六枚”十六字。

410.赵本、《集成》“已后”作“以后”。《千金翼》、赵本“发热”下无“者”字；“脉沉实”下同有“一作紧”小三字。

411.《千金翼》“差后”作“已后”，无“已”字。《玉函》、赵本、《集成》“已下”作“以下”。《玉函》、《千金翼》“水气”下无“者”字。

牡蛎泽泻散方：

《玉函》“海藻”下无“已上”二字。《玉函》、赵本、《医统》“蜀漆”下“洗去脚”作“洗去腥”。赵本“蜀漆”下有“煖水”二字。《千金翼》蜀漆下只一“洗”字，“海藻”下亦只一“洗”字。赵本、《集成》“更入臼中”作“更于臼中”。“日三”下《医统》无“服”字；赵本、《集成》“日三服”在“小便利”之前；“葶苈”下有“子”字；“海藻”下无“已上各等分”五字及“咸寒”二字。《玉函》作“右七味为散，白饮和服方寸匕，小便利即止”；《千金翼》作“右七味，捣为散，饮服方寸匕，日三服，小便即利”。

412.《千金翼》“差后”作“已后”。《玉函》、《千金翼》“喜唾”上有“其人”二字。《千金翼》“久不了了”作“久久不了”，无“者”字。《千金翼》、赵本“胃上”作“胸上”。《千金翼》、《玉函》“温之”上无“以丸药”三字。《玉函》、《医统》“丸”皆作“圆”。《千金翼》本条列于下条（413）之后。

413.《千金翼》本条列在上条（412）之前。《千金翼》、《玉函》、赵本“气逆欲吐”下皆无“者”字。

竹叶石膏汤方：

《千金翼》石膏一斤下有“碎”字。《玉函》“半夏”下无“洗”字。《集成》、赵本“人参”皆作二两。《集成》“甘草”作“一两”。《千金翼》“熟汤成”上无“煮米”二字，下无“去米”二字。赵本、《集成》药名后皆无性味。“麦门冬”列在“半夏”之后。

414. 《玉函》“病人”作“伤寒”；“微烦”下有“者”字；“则愈”作“即愈”。



刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编
■ 刘渡舟 编著

现代著名老中医名著重刊丛书

刘渡舟医书七种

第十辑

新编伤寒论 类方



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·第十辑
刘渡舟医书七种

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编



新编伤寒论 类方

编著 刘渡舟
整理 武 岩 张光华 吴凤全 尉敏廷

人民卫生出版社

版权页

图书在版编目（**CIP**）数据

新编伤寒论类方/刘渡舟编著. —北京：人民卫生出版社，2013

（现代著名老中医名著重刊丛书.第10辑，刘渡舟医书七种）

ISBN 978-7-117-17356-8

I. ①新... II. ①刘... III. ①《伤寒论》-研究IV. ①R222.29

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第120946号

人卫智网 **www.ipmph.com** 医学教育、学术、考试、健康，购
书智慧智能综合服务平台

人卫官网 **www.pmph.com** 人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

现代著名老中医名著重刊丛书（第十辑）

刘渡舟医书七种

新编伤寒论类方

丛书主编：王庆国 刘燕华

编 著：刘渡舟

出版发行：人民卫生出版社有限公司

人民卫生电子音像出版社有限公司

地 址：北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编：100021

E - mail: ipmph@pmph.com

制作单位：人民卫生电子音像出版社有限公司

排 版：人民卫生电子音像出版社有限公司

制作时间：2018年1月

版本号：V1.0

格式：mobi

标准书号：ISBN 978-7-117-17356-8

策划编辑：李丽

责任编辑：李丽

打击盗版举报电话：**010-59787491** E-mail: **WQ@pmph.com**

注：本电子书不包含增值服务内容，如需阅览，可购买正版纸质图书。

刘渡舟医书七种编写委员会

主 编

王庆国 刘燕华

副主编

李宇航 梁永宣

编 委（以姓氏笔画为序）

于博睿 马小娜 马春雷 王 冬 王庆国

王国华 王利敏 王雪茜 刘 敏 刘丹彤

刘晓倩 刘晓辉 刘燕华 闫军堂 许仲宁

孙 燕 孙良明 孙晓东 李 欣 李成卫

李宇航 李丽娜 李晓莉 李鹏英 吴范武

张 欢 张 娜 张雪亮 陈 明 陈 萌

畅洪昇 周 刚 郑丰杰 房克英 屈会化

赵 妍 赵 琰 赵伟鹏 赵宇明 钟相根

贾春华 倪 磊 高 飞 郭书文 梁永宣

程发峰 傅延龄 鲁 艺 赛佳洋

学术秘书

闫军堂

出版说明

自20世纪60年代开始，我社先后组织出版了一些著名老中医经验整理著作，包括医案、医论、医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国现代中医学术的发展发挥了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显。这些著名老中医在我国近现代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。他们的著作多成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前。无论是亲自撰述，还是口传身授，或是由其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华。诸位名老中医不吝秘术，广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，今已很难见到，部分著作甚至已成为中医读者的收藏珍品。为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将部分具有较大影响力的名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》并分辑出版，以飨读者。

第一辑 收录13种名著

- | | |
|-------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |
| 《钱伯煊妇科医案》 | 《朱小南妇科经验选》 |
| 《赵心波儿科临床经验选编》 | 《赵锡武医疗经验》 |
| 《朱仁康临床经验集——皮肤外科》 | |

《张赞臣临床经验选编》

第二辑 收录14种名著

《中医入门》 《章太炎医论》

《冉雪峰医案》 《菊人医话》

《赵炳南临床经验集》 《刘奉五妇科经验》

《关幼波临床经验选》 《女科证治》

《从病例谈辨证论治》 《读古医书随笔》

《金寿山医论选集》 《刘寿山正骨经验》

《韦文贵眼科临床经验选》 《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑 收录20种名著

《内经类证》 《金子久专辑》

《清代名医医案精华》 《陈良夫专辑》

《清代名医医话精华》 《杨志一医论医案集》

《中医对几种急性传染病的辨证论治》

《赵绍琴临证400法》 《潘澄濂医论集》

《叶熙春专辑》 《范文甫专辑》

《临诊一得录》 《妇科知要》

《中医儿科临床浅解》 《伤寒挈要》

《金匱要略简释》 《金匱要略浅述》

《温病纵横》 《临证会要》

《针灸临床经验辑要》

第四辑 收录6种名著

《辨证论治研究七讲》 《中医学基本理论通俗讲话》

《黄帝内经素问运气七篇讲解》 《温病条辨讲解》

《医学三字经浅说》 《医学承启集》

第五辑 收录19种名著

《现代医案选》 《泊庐医案》

《上海名医医案选粹》 《治验回忆录》

《内科纲要》 《六因条辨》
《马培之外科医案》 《中医外科证治经验》
《金厚如儿科临床经验集》 《小儿诊法要义》
《妇科心得》 《妇科经验良方》
《沈绍九医话》 《著园医话》
《医学特见记》 《验方类编》
《应用验方》 《中国针灸学》
《金针秘传》

第六辑 收录11种名著

《温病浅谈》 《杂病原旨》
《孟河马培之医案论精要》 《东垣学说论文集》
《中医临床常用对药配伍》 《潜厂医话》
《中医膏方经验选》 《医中百误歌浅说》
《中药炮制品古今演变评述》 《赵文魁医案选》
《诸病源候论养生方导引法研究》

第七辑 收录15种名著

《伤寒论今释》 《伤寒论类方汇参》
《金匱要略今释》 《杂病论方证捷咏》
《金匱篇解》 《中医实践经验录》
《罗元愷论医集》 《中药的配伍运用》
《中药临床生用与制用》 《针灸歌赋选解》
《清代宫廷医话》 《清宫代茶饮精华》
《常见病验方选编》 《中医验方汇编第一辑》
《新编经验方》

第八辑 收录11种名著

《龚志贤临床经验集》 《读书教学与临症》
《陆银华治伤经验》 《常见眼病针刺疗法》
《经外奇穴纂要》 《风火痰瘀论》

《现代针灸医案选》 《小儿推拿学概要》

《正骨经验汇萃》 《儿科针灸疗法》

《伤寒论针灸配穴选注》

第九辑 收录11种名著

《书种室歌诀二种》 《女科方萃》

《干祖望医话》 《名老中医带教录》

《班秀文妇科医论医案选》 《疑难病证治》

《清宫外治医方精华》 《清宫药引精华》

《祝谌予经验集》 《疑难病证思辨录》

《细辛与临床》（附 疑难重奇案七十三例）

第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）

《伤寒论十四讲》 《伤寒论通俗讲话》

《伤寒论诠解》 《新编伤寒论类方》

《经方临证指南》 《金匱要略诠解》

《肝病证治概要》

这些名著大多于20世纪60年代前后至90年代后在我社出版，自发行以来一直受到广大读者的欢迎，其中多数品种的发行量达到数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床诊疗水平和促进中医事业发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时尽可能保持原书原貌，只对原著中有欠允当之处及疏漏等进行必要的修改。为不影响原书内容的准确性，避免因换算等造成的人为错误，对部分以往的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的临床检测项目与方法等，均未改动，保留了原貌。对于原著中犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社
2013年3月

整理说明

刘渡舟是北京中医药大学已故终身教授、《伤寒论》专业首批博士生导师，当代著名的中医学大家、中医教育家。刘老行医、执教半个多世纪，上溯岐黄之道，下逮诸家之说，力倡仲景之学，博采众长，学验宏富，形成了鲜明的学术思想和医疗风格，被誉为“伤寒泰斗”、“经方大家”，日本汉方界更称其为“中国治伤寒第一人”，其学术成就为中医同仁所公认，在中医学界享有盛誉。刘老以振兴中医、培育桃李为己任，在繁忙的医疗、教学、科研之余，坚持著书立说，笔耕不辍，培养后学。刘老一生著述颇丰，曾出版中医学术著作20多部，发表学术论文100余篇，为传承中医药事业作出了杰出贡献。

20世纪80年代，刘老的学术经验日臻成熟与完善，在当时十多年的时间里，他出版了数十部关于《伤寒论》、《金匱要略》及经方运用的研究专著，具有很高的学术水平和临床应用价值，深受广大读者欢迎，在中医学界产生了很大的影响，对于推动仲景学术发展和提高中医临床水平起到了重要的作用。为了系统总结刘老的学术思想和医疗经验，并从中窥探其治学方法与道路，我们精选了最能反映刘老治伤寒、用经方、精临证的学术著作，经撰次整理，辑而成帙，名为《刘渡舟医书七种》，付梓再版，以飨读者。这7本代表性医书分别是《伤寒论十四讲》、《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论诠解》、《新编伤寒论类方》、《经方临证指南》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》。这些著作能突出反映刘老之方证相对论、辨证知机论、古今接轨论、气机论、攻邪论、水火论、湿证论、脾胃论、肝胆论以及抓主证等学术思想及其对经方的运用经验，汇集了刘老行医50余年的学术经验和心血结晶，贯彻了理论和实践相结合的方针。通过阅读刘老文稿，读者可窥其学术思想和临床经验之一斑，并有助于系统地掌握刘老的临证特色和诊治经验。编撰者也希望通过这些文字笔墨展示经方大家刘渡舟教授的学术经历及成就，使一代名家为中医药事业不屈不挠的奋斗精神、人格品质及宝贵经验得以传世后人，为中国医学史树起一座不朽的丰碑。

为了使读者能原汁原味地阅读刘老著作，本次修订再版《刘渡舟医

书七种》时，采取尽可能保持原书原貌的原则，除对原著中出现的文字、标点错误稍加更正，并在不影响文意的前提下润色语句不通顺之处外，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排，从而规范了原书的体例层次。而对原书中出现的古今字、异体字、繁简字以及以往的病名、药名、计量单位等，均未改动，保留了原貌。

2007年，为了整理、挖掘、继承和抢救京城名老中医的学术经验，北京市中医管理局启动了“名老中医药专家学术思想抢救挖掘与优秀传承人才培养联动工程”（简称“薪火传承3+3工程”），目的在于做好首都名老中医学术思想的抢救、整理和挖掘工作。刘渡舟名家研究室

（No.2007-SZ-A-09）于2007年10月首批获北京市中医管理局批准，2008年1月授牌，2008年6月正式启动建设，进行了大量卓有成效的工作。将刘老积累多年的学术著作、文章、讲稿等整理、汇编、出版更是研究室的重要工作之一，本书即是在研究室全体成员的共同努力之下完成的，在此，谨向名家研究室这一名老中医学术经验平台的发起者——北京市中医管理局致以崇高的敬意。同时，也向所有参与此次编撰工作的各位同仁致以谢意。

刘渡舟名家研究室主任
北京中医药大学副校长，教授、博士生导师
王庆国
2012年12月

前言

自《伤寒论》问世以来，为之注释者，大有人在。其中提出“以方归类”的，则以清人徐灵胎为代表。徐氏博学广识，对伤寒造诣颇深。他认为仲景之书，乃救误之书，当时随证立方，本无定序，于是消除阴阳六经门目，但使方以类从，证随方列，使人可案证以求方，而不必循经以求证。虽于古人著书本意未必果符，而于聚讼纷呶之中，亦芟除葛藤之一术也。因此，提出了不类经而类方的整理方法。并在这一思想指导下，写出了《伤寒论类方》一书，对《伤寒论》的研究和发展作出了不可磨灭的贡献。然而，也应该看到，徐氏在写作上还存在着文简而义略的倾向，再加上当时的条件所限，难免还有这样或那样的缺欠，这就需要我们进一步加以整理，而使其更加完善。为此，不揣肤浅，在徐氏类方的基础上，沿用了类方概证方法，又进行了加工和补充，书名曰《新编伤寒论类方》，以资与旧《类方》而有所区别。

本书引用的条文和方剂，以明朝赵开美复刻的《伤寒论》为蓝本。同时，还把煎服法中的“右”字均改为“上”字。在体例上设有：概述、方名、药物组成、煎服法、加减法、适应证、原文、方义、选注、按语、方歌、医案选录等十二个环节。力求读者从方以识证，从证而知辨，使方证一脉贯通，而能起到纲举目张之效，用以指导临床辨证论治，而为本书之宗旨。惟书中的禹余粮丸和土瓜根导两方，其方亡佚，故不录。

刘渡舟于北京
1983年1月5日

Table of Contents

桂枝汤类概述

- 一、桂枝汤
- 二、桂枝加葛根汤
- 三、桂枝加附子汤
- 四、桂枝去芍药汤
- 五、桂枝去芍药加附子汤
- 六、桂枝麻黄各半汤
- 七、桂枝二麻黄一汤
- 八、桂枝二越婢一汤
- 九、桂枝去桂加茯苓白术汤
- 十、桂枝加厚朴杏子汤
- 十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤
- 十二、桂枝甘草汤
- 十三、小建中汤
- 十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤
- 十五、桂枝加桂汤
- 十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- 十七、桂枝附子汤
- 十八、去桂加白术汤
- 十九、桂枝加芍药汤
- 二十、桂枝加大黄汤
- 二十一、桂枝人参汤

麻黄汤类概述

- 一、麻黄汤
- 二、大青龙汤
- 三、小青龙汤
- 四、麻黄杏仁甘草石膏汤
- 五、麻黄连翘赤小豆汤
- 六、麻黄细辛附子汤
- 七、麻黄附子甘草汤
- 八、麻黄升麻汤

葛根汤类概述

- 一、葛根汤
- 二、葛根加半夏汤
- 三、葛根黄芩黄连汤

抵当汤类概述

- 一、桃核承气汤
- 二、抵当汤
- 三、抵当丸

栀子豉汤类概述

- 一、栀子豉汤
- 二、栀子甘草豉汤
- 三、栀子生姜豉汤
- 四、栀子厚朴汤
- 五、栀子干姜汤
- 六、枳实栀子豉汤
- 七、栀子柏皮汤

陷胸汤类概述

- 一、大陷胸丸
- 二、大陷胸汤
- 三、十枣汤
- 四、小陷胸汤
- 五、白散
- 六、瓜蒂散

泻心汤类概述

- 一、半夏泻心汤
- 二、大黄黄连泻心汤
- 三、附子泻心汤
- 四、生姜泻心汤
- 五、甘草泻心汤
- 六、旋覆代赭汤

甘草汤类概述

- 一、甘草汤

[二、炙甘草汤](#)

[三、甘草附子汤](#)

[四、甘草干姜汤](#)

[苓桂术甘汤类概述](#)

[一、茯苓桂枝白术甘草汤](#)

[二、茯苓桂枝甘草大枣汤](#)

[三、茯苓甘草汤（苓桂姜甘汤）](#)

[四、五苓散](#)

[五、猪苓汤](#)

[六、文蛤散](#)

[黄芩黄连汤类概述](#)

[一、黄芩汤](#)

[二、黄芩加半夏生姜汤](#)

[三、黄连汤](#)

[四、黄连阿胶汤](#)

[白虎汤类概述](#)

[一、白虎汤](#)

[二、白虎加人参汤](#)

[三、竹叶石膏汤](#)

[承气汤类概述](#)

[一、调胃承气汤](#)

[二、小承气汤](#)

[三、大承气汤](#)

[四、麻子仁丸](#)

[五、蜜煎导方](#)

[六、猪胆汁灌方](#)

[柴胡汤类概述](#)

[一、小柴胡汤](#)

[二、大柴胡汤](#)

[三、柴胡加芒硝汤](#)

[四、柴胡桂枝汤](#)

[五、柴胡桂枝干姜汤](#)

[六、柴胡加龙骨牡蛎汤](#)

[七、四逆散](#)

[芍药当归汤类概述](#)

[一、芍药甘草汤](#)

[二、芍药甘草附子汤](#)

[三、当归四逆汤](#)

[四、当归四逆加吴茱萸生姜汤](#)

[干姜汤类概述](#)

[一、干姜附子汤](#)

[二、干姜黄芩黄连人参汤](#)

[三、理中丸（汤）](#)

[赤石脂汤类概述](#)

[一、赤石脂禹余粮汤](#)

[二、桃花汤](#)

[四逆汤类概述](#)

[一、四逆汤](#)

[二、四逆加人参汤](#)

[三、茯苓四逆汤](#)

[四、通脉四逆汤](#)

[五、通脉四逆加猪胆汁汤](#)

[六、真武汤](#)

[七、白通汤](#)

[八、白通加猪胆汁汤](#)

[九、附子汤](#)

[杂方类概述](#)

[一、厚朴生姜半夏甘草人参汤](#)

[二、茵陈蒿汤](#)

[三、猪肤汤](#)

[四、桔梗汤](#)

[五、苦酒汤](#)

[六、半夏散及汤](#)

[七、乌梅丸](#)

[八、白头翁汤](#)

[九、吴茱萸汤](#)

[十、烧裨散](#)

[十一、牡蛎泽泻散](#)

[返回总目录](#)

桂枝汤类概述

桂枝汤类计有二十一方，是全书最多的一组类方。桂枝汤类应以桂枝汤方为代表。桂枝汤用途极广，它能滋阴和阳、解肌祛风、外调荣卫、内和脾胃，故不惟发汗以止汗，且发汗而不伤正，止汗而不留邪，又能对汗下后的表不解，或无关中风而荣卫不和等证均可用它治疗。

桂枝汤的加减方法有两种不同的情况：如桂枝汤或加葛根，或加附子，或加厚朴、杏仁等，则属于治疗太阳中风兼证而设，此时仍有风邪在表不解。至于桂枝汤或者增桂枝剂量，或者增加芍药剂量，抑或减去桂枝，或减去芍药等方，乃是中风表邪已解，为治疗各类杂病而设。另外，还有只以桂枝为名（如桂枝人参汤），其实并非桂枝汤加减之方，为了连类发明，也将它归纳于桂枝汤类进行论述。

学习本门方证，可以掌握对桂枝汤的运用，以及加减方证的灵活变化。还可看到桂枝汤的一药之增减，则原有证候面目全非，治疗的性质也随之而变。可见，经方用药如此严谨，对人的启发是很大的。

一、桂枝汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 芍药三两 甘草（炙）二两 生姜（切）三两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上五味，**㕮**咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令以一二时许，遍身**𦵏𦵏**微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂。若不汗，更服，依前法。又不汗，后服小促其间，半日许令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

【适应证】

（一）适用于太阳中风，头痛、发热、汗出、恶风、鼻鸣、流涕、干呕、舌苔薄白、脉浮缓等证。

（二）适用于表证或汗或下，而外证未解，脉见浮弱者，或下后其气上冲，或发汗后脉洪大而不烦渴者。

（三）适用于脏无他病，外见营卫失调，而时发热自汗出者。

（四）适用于头痛有热，不大便六七日，脉浮而小便色白者。

【原文】

第12条、13条、15条、16条、17条、19条、24条、25条、42条、44条、45条、53条、54条、56条、57条、91条、95条、164条、234条、240条、276条、372条、387条。

【方义】

本方为解肌祛风，调和营卫而设。桂枝辛温，通阳散寒；芍药酸苦微寒，益营敛阴。桂芍相配，于解肌中寓敛汗之意，和营中有调卫之

功。生姜辛散，温胃止呕，佐桂枝以发汗通阳；大枣甘缓，助芍药以敛汗护阴；甘草调和阴阳，既可佐桂枝辛甘发散，以祛在表之邪，又可助芍药酸甘化阴，以和在里之营，而能安内攘外，调和诸药。

【选注】

《医宗金鉴》：“名曰桂枝汤者，君以桂枝也。桂枝辛温，辛能发散，温通卫阳。芍药酸寒，酸能收敛，寒走营阴。桂枝君芍药，是于发汗中寓敛汗之旨；芍药臣桂枝，是于和营中有调卫之功。生姜之辛，佐桂枝以解表；大枣之甘，佐芍药以和中。甘草甘平，有安内攘外之能，用以调和中气，即以调和表里，且以调和诸药。以桂芍之相须，姜枣之相得，借甘草之调和，阳表阴里，气卫血营，并行而不悖，是刚柔相济以相和也。”

【按语】

本方发汗而不伤正，止汗而不留邪，外能解散风邪、调营卫，内能理气血、协阴阳、和脾胃。它应用十分广泛，不仅用于外感，亦多用于杂病。凡由于气血不和、营卫失调引起的发热、汗出、脉弱等证，均可用本方治疗。仲景把桂枝汤列为第一方的意义，在于它的调和营卫、气血、阴阳，而有寓方于治的精神在内，体现出“察色按脉，先别阴阳”的这一原则。

使用本方时，桂枝与芍药的剂量要相等，否则，不能起到调和营卫的作用。本方凡增减桂枝、白芍任何一种药剂，都会改变其治疗的意义。

还应指出，服用桂枝汤，一定要喝热稀粥，这既可助药力以发汗，又可益胃气以资汗源。服药后，应当盖被避风，而有利于发汗的作用。此方不发汗则不能祛除风邪，但发汗以微似汗出者为佳，而不可令如水流漓。汗出中病，余药可不必再服。若不汗出，应当继续服药，并可缩短服药时间，以催促汗出。如汗不出，可连续服用二三剂，以汗出病解为目的。

本方对太阳病发热、无汗、脉浮紧的伤寒表实证，证类外感的酒客病，以及温病舌红口渴的，均应禁服。

【方歌】

桂枝汤方桂芍草，佐用生姜和大枣；
啜粥温服取微汗，调和营卫解肌表。

【医案选录】

余曾于某年夏，治一同乡杨兆彭。病先其人畏热，启窗而卧，周身热汗淋漓，风来适体，乃即睡去。夜半觉冷，覆被再睡，其冷不减，反加甚。次日诊之，病者头有汗，手足心有汗，背汗不多，周身汗亦不多，当与桂枝汤原方：

桂枝三钱，白芍三钱，甘草一钱，生姜三片，大枣三枚。

又次日，未请复诊。后以他病来乞治，曰：“前次服药后，汗出不少，病遂告瘥。药力何其峻也？”然安知此方乃吾之轻剂乎？

（摘《经方实验录》第2页）

二、桂枝加葛根汤

【药物组成】

葛根四两 芍药二两 生姜（切）三两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚 桂枝（去皮）二两

【煎服法】

上七味，以水一斗，先煮葛根，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。

【适应证】

适用于太阳中风，发热汗出而兼有项背强几几证。

桂枝汤能解肌祛风，调和营卫，加葛根，既可加强解肌祛风的作用，又可疏通经脉的凝滞，而又升腾津液，以滋润筋脉的拘紧，则项背强几几自然得愈。

【原文】

第14条。

【方义】

【选注】

张志聪：“此承上文头痛而及于项背，以见太阳循经自上而下之义也。太阳经脉，循于脊背之间，今风邪涉于分部，而经气不舒，故项背而几几然也。是当无汗，反汗出者，肌腠不密也。肌腠虚，故恶风。用桂枝汤以解太阳肌中之邪，加葛根宣通经脉之气，而治太阳经脉之邪。”

【按语】

成无己云：“几几者，伸颈之貌也。动则伸颈，摇身而行。项背

强者，动则如之。”这是风邪客于太阳经脉，经气不能流通，筋脉失于濡养的表现。加葛根以宣通经络之滞，又可升腾津液而滋筋脉之拘急。后世还用本方治疗外感不解，而又有下利之证，或治疗风寒背部痹痛，以及下颌关节炎等也都有效。

桂加葛根走经输，项背**几几**反汗濡；
解肌祛风滋经脉，用治柔痉理不殊。

【方歌】

【医案选录】

庚戌，建康徐南强得伤寒，背强、汗出、恶风。予曰：桂枝加葛根汤证。病家曰：他医用此方，尽二剂而病如旧，汗出愈加。予曰：得非仲景三方乎？曰：然。予曰：误矣。是方有麻黄，服则愈见汗多。林亿谓止于桂枝加葛根汤也。予令生而服之，微汗而解。

（摘许叔微《伤寒九十论》第19页）

三、桂枝加附子汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 芍药三两 甘草（炙）三两 生姜（切）三两 大枣（擘）十二枚 附子（炮、去皮、破八片）

【煎服法】

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今加附子，将息如前法）

【适应证】

治发汗后遂漏不止，恶风寒，四肢拘急疼痛，屈伸不便，而小便难。

【原文】

第20条。

【方义】

用桂枝汤调和营卫，加附子扶阳温经固表。俾阳能摄阴，则漏汗止，营卫调和而诸证可愈。

【选注】

成无己：“太阳病，因发汗，遂汗漏不止而恶风者，为阳气不足；因发汗，阳气益虚而皮肤不固也。《内经》曰：‘膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则出’。小便难者，汗出亡津液，阳气虚弱，不能施化。四肢者，诸阳之本也，四肢微急，难以屈伸者，亡阳而脱液也。《针经》曰：‘液脱者，骨属屈伸不利’。与桂枝加附子汤，以温经复阳。”

尤在泾：“夫阳者，所以实腠理、行津液、运肢体者也。今发汗而使阳虚，既不能护其外，又不能温其里，则汗出而小便难矣。邪风之气，亦不能随汗而解，所以恶风、四肢微急、难以屈伸。”

【按语】

桂枝加附子汤为表阳虚而风邪不解设，或因外邪不解而又误治伤阳之证。来路虽不尽同，然阳虚而兼外感则一。这里的辨证关键是汗出不止，然脉必浮而不沉。若汗多脉沉，则为亡阳之征，非四逆汤则不可为功。

本方还治疗风寒肢痛，脉沉而弦，而有温经散寒之用。若因风寒痹阻的肌肤麻木不仁，可酌加当归、红花等理血之品，则效果为更捷。

【方歌】

桂加附子治有三，风寒肢痛脉迟弦；
汗漏不止恶风甚，肌肤麻木卫阳寒。

【医案选录】

顾某，卫气素虚，皮毛不固，动则汗出。忽感风邪，始则啬啬恶寒，淅淅恶风，继则翕翕发热，腰臂酸楚，间以恶心、自汗淋漓。迁延两日，病势有增，四肢拘急，屈伸不利，手足发冷，延余就诊。见其面带垢晦，怯手缩足，自汗颇多，气息微喘。此太阳表证，卫虚未厥，必需一鼓而克之，否则顾此失彼，难保无肢厥脉沉之虞。乃处以桂枝加附子汤：桂枝三钱、芍药四钱、炙甘草二钱半、熟附片五钱、生姜钱半、大枣十枚，一剂而愈。”

（摘《江苏中医》1959，5：16）

有一士人得太阳证，因发汗，汗不止，恶风，小便涩，足挛曲而不伸。予诊其脉浮而大，浮为风，大为虚。予曰：在仲景方中有两证大同而小异，一则小便难，一则小便数。用药稍差，有千里之失。仲景第七证云：太阳病，发汗遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤。第十六证云：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝汤欲攻其表，此误也。得之便厥，咽中干，烦躁吐逆。一则漏风小便难，一则自汗小便数，或恶风，或恶寒，病各不同也。予用第七证桂枝加附子汤，三啜而汗止。复佐以甘草芍药汤，足便得伸。”

（摘《普济本事方》第106页）

四、桂枝去芍药汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 甘草（炙）二两 生姜（切）三两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上四味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今去芍药，将息如前法。）

【适应证】

误下以后，心胸阳气受挫，表邪内陷，出现脉促、胸满等证。

【原文】

第21条。

【方义】

误下以后，心胸之阳虽伤，而犹能鼓其力以抗邪，故胸虽满而脉反促。桂枝配甘草辛甘化阳，以温心胸之阳气；生姜、大枣调和营卫，务使陷入之邪由胸出表，得以外解。去芍药之义，因其酸收，而反掣桂枝之肘，此乃治阳而远阴之义。

【选注】

成无己：“太阳病下之，其脉促不结胸者，此为欲解。此下后脉促而胸满，则不得为欲解，由下后阳虚，表邪渐入而客于胸中也。与桂枝汤以散客邪，通行阳气。芍药益阴，阳虚者非所宜，故去之。”

【按语】

太阳病误下伤正，表邪乘虚内陷。表与胸通，故首先犯胸，胸阳受挫，然犹能力争，故脉来急促。“满”读为“闷”，是邪客胸中，胸阳不振的反映。邪虽入胸，从脉促分析，仍有出表之势，故用桂枝汤去芍药，调和营卫，宣通胸阳，因势利导，则诸证可愈。

本证除有胸满外，往往伴有心悸、咳逆、短气等证。

【方歌】

桂枝去芍药何居，胸满心悸膺中虚；
若见咳逆和短气，桂甘姜枣治无遗。

【医案选录】

李某，女，46岁。患“心肌炎”，入夜则胸满气短，必吸入氧气始得缓解。切其脉弦而缓，视其舌淡而苔白。辨为胸阳不振，阴霾内阻之证。为疏桂枝去芍药汤，两剂而证减，后又改加附子而获愈。

（刘渡舟医案）

五、桂枝去芍药加附子汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 甘草（炙）二两 生姜（切）三两 大枣（擘）十二枚 附子（炮、去皮、破八片）一枚

【煎服法】

上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今去芍药，加附子，将息如前法。）

【适应证】

上述桂枝去芍药汤证，又见阳虚而微恶风寒证。

【原文】

第22条。

【方义】

误下后，脉促胸满，阳气虽力争，然已成颓势，故又见恶寒之证。于上方再加附子温经以扶阳。

【选注】

柯韵伯：“太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。若更见微恶寒者，去芍药方中加附子主之。夫促为阳脉，胸满为阳症，然阳盛则促，阳虚亦促；阳盛则胸满，阳虚亦胸满。此下后脉促而不汗出，胸满而不喘，非阳盛也，是寒邪内结，将作结胸之脉。桂枝汤阳中有阴，去芍药之寒酸，则阳气流行而邪自不结，即扶阳之剂矣。若微见恶寒，则阴气凝聚，恐姜桂之力薄不能散邪，加附子之辛热，为纯阳之剂矣。仲景于桂枝汤一减一加，皆成温剂，而更有浅深之殊也。”

【按语】

本方证情比桂枝去芍药汤更重一层。此时阳气转衰，不但脉促胸满，而又兼见恶寒，故于桂枝去芍药汤中再加附子，补阳消阴，力大气雄，方能胜任。本方不仅适用于外感病的误治变证，而对胸阳不振、阴

寒内盛的“胸痹”证也有较好的疗效。

对于本证脉促主寒主热也有争议。程郊倩说：“有阳盛而见脉促，亦有阳虚而见脉促者，当辨于有力无力。”可见本证当为促而无力者。

【方歌】

桂枝去芍避阴寒，加附助阳理固然；
脉促无力舌质淡，胸痹治法非等闲。

【医案选录】

王某，男，36岁。自述胸中发满，甚或作痛，每逢冬季发作更甚，兼见咳嗽、气短。切其脉弦而缓，扪其手则凉而不温，问其小便则清白而长。参合上述脉证，诊为胸阳不振而阴寒上踞。处方用：桂枝9克，生姜9克，炙甘草6克，大枣7枚，附子9克。

服此方数剂，而胸满气短皆愈。

（刘渡舟医案）

六、桂枝麻黄各半汤

【药物组成】

桂枝（去皮）一两十六铢 芍药 生姜（切） 甘草（炙） 麻黄（去节）各一两 大枣（擘）四枚 杏仁（汤浸去皮尖子及两仁者）二十四枚

【煎服法】

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。（本云桂枝汤三合，麻黄汤三合，并为六合，顿服。将息如上法。）

【适应证】

太阳病八九日不解，病如疟状，发热恶寒，热多寒少，一日二三次发，面色发红，阳郁不伸而周身发痒。

【原文】

第23条。

【方义】

本方取桂枝汤、麻黄汤各三分之一的剂量，属于小汗之法。一般认为：无汗不得用桂枝汤，邪微不得用麻黄汤。本方取小剂量的桂枝汤与麻黄汤合方，吸两方之长，弃两方之短，使之疏解肌表，发散小邪，实有刚柔相济、邪去而不伤正之美。

【选注】

柯韵伯：“太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，面有赤色者，是阳气怫郁在表不得越。因前此当汗不汗，其身必痒。法当小发汗，故以麻桂二汤各取三分之一，合为半服而急服之。盖八九日来，正气已虚，表邪未解，不可不汗，又不可多汗。多汗则转属阳明，不汗则转属少阳。此欲只从太阳而愈，不再作经，故立此法耳。”

【按语】

本证邪气虽微，但郁久不汗，其身必痒，故不汗不可，汗多也不

可。用麻黄汤则嫌其峻，用桂枝汤则又虑其缓，故两方合用则愈。正如尤在泾说：“桂枝麻黄各半汤，助正之力，俾于散邪。”说的非常恰当。

【方歌】

桂加麻杏名各半，肌表小邪不得散；
面有热色身亦痒，两方合用发小汗。

【医案选录】

尝记一亲戚病伤寒，身热、头痛、无汗，大便不通已四五日。予讯问之，见医者治大黄、朴硝等欲下之。予曰：子姑少待，予为视之。脉浮缓，卧密室中，自称其恶风。予曰：表证如此，虽大便不通数日，腹又不胀，别无所苦，何遽便下？大抵仲景法须表证罢方可下，不尔，邪乘虚入，不为结胸，必为热利也。

予作：桂枝麻黄各半汤，继以小柴胡汤，**淅淅**汗出，大便亦通而解。

（摘《普济本事方》第120页）

七、桂枝二麻黄一汤

【药物组成】

桂枝（去皮）一两十七铢 芍药一两六铢 麻黄（去节）十六铢 生姜（切）一两六铢 杏仁（去皮尖）十六个 甘草（炙）一两二铢 大枣（擘）五枚

【煎服法】

上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升，日再服。（本云桂枝汤二分，麻黄汤一分，合为二升，分再服。今合为一方，将息如前法。）

【适应证】

服桂枝汤大汗出后，寒热如疟，一日二、三度发。

【原文】

第25条。

【方义】

此证已经大汗，正气已虚，故取桂枝汤三分之二，解肌以调营卫；又寒热似疟而邪未尽解，故取麻黄汤三分之一，用以发表祛邪。

【选注】

《医宗金鉴》：“若形如疟，日再发者，虽属轻邪，然终是为风寒所持，非汗出必不得解，故宜桂枝二麻黄一汤，小发荣卫之汗。其不用麻黄桂枝各半汤者，盖因大汗已出也。”

徐大椿：“此与桂枝麻黄各半汤意略同。但此因大汗出之后，故桂枝略重，而麻黄略轻。”

【按语】

此证邪微而正亦受虚，故少用麻黄略开郁闭之表，增用桂枝以助正而祛邪。桂麻合剂药味全同，而药量则稍有差异。这种组方纤细不苟的精神，是值得我们学习的。

【方歌】

桂二麻一名合方，寒热如疟治法良；
大汗之后表未解，去邪同时正亦匡。

【医案选录】

刘某，女，12岁。初春感受风寒，头疼发热。家人为购“平热散”服之，汗出较多，继之热退。然甫一日，又见发热、恶寒，其形如疟，上午发一次，下午则发作两次。切其脉浮而略数，视其舌苔薄白而润。辨为发汗过多，而营卫之邪反稽留不解，乃法仲景之桂二麻一汤。

桂枝5克，白芍5克，生姜5克，炙麻黄3克，炙甘草3克，大枣3枚，杏仁3克。

服药后，微微汗出，嘱其避风慎食，因之而解。

（刘渡舟医案）

八、桂枝二越婢一汤

【药物组成】

桂枝（去皮） 芍药 麻黄 甘草（炙）各十八铢 大枣（擘）四枚 生姜（切）一两二铢 石膏（碎，绵裹）二十四铢

【煎服法】

上七味，以水五升，煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。（本云：当裁为越婢汤、桂枝汤，合之饮一升。今合为一方，桂枝汤二分，越婢汤一分。）

【适应证】

太阳病日久不解，发热恶寒，热多寒少，而脉由紧变弱，寒欲化热者。

【原文】

第27条。

【方义】

本方是桂枝汤与越婢汤合方，但剂量较小。取桂枝和麻黄小发其汗，以散在表之邪；纳石膏之辛凉清泄，以解郁遏之热。证因“热多寒少”，故小汗中须佐辛凉而为佳。

【选注】

《医宗金鉴》：“此方即大青龙汤以芍药易杏仁也。名虽越婢，辅桂枝，实则大青龙汤变制也。去杏仁，恶其从阳而辛散；用芍药，以其走阴而酸收，以此易彼，裁而用之，则主治不同矣。以桂枝二主之，则不发汗可知，越婢一者，乃麻黄、石膏二物，不过取其辛凉之性，佐桂枝二以和表而清肌热，则是寓微汗于不发之中，亦可识也。非若大青龙汤以石膏佐麻黄，而为发汗驱肌热之重剂也。”

【按语】

此方正如《医宗金鉴》所说，名虽越婢辅桂枝，实则大青龙之变制

也。当然，由于它的剂量甚微，而且又去掉降利肺气的杏仁，加了酸收的芍药，发汗之力就十分微弱。本方于辛温中配有石膏，就为辛凉清解之法开辟了先河。

对本方证的解释历来不一。有的医家认为：“宜桂枝二越婢一汤”应接“热多寒少”下；“脉微弱者，此无阳也，不可发汗”则是阳虚之脉，而属于另一种病机，与本文无关。我们认为：“脉微弱”是与脉浮紧对比而言，因邪渐化热，故脉由紧急而变弛缓，并非亡阳的微脉，况“无阳”也不等于“亡阳”。观46条“服药已微除，其人发烦目瞑，刷牙必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。”这里的“阳”指的表邪而言，可见“无阳”是指表不实的意思。所以，不可用麻黄汤峻发其汗，而改用桂枝二越一小发其汗。以方测证，应当有热证出现。

桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤与桂枝二越婢一汤，是《伤寒论》中三个小汗之方，补充了桂枝汤和麻黄汤两方之不足，适用于太阳表不解的轻证。桂麻各半汤和桂二麻一汤，病情单纯，仅为表邪未解，前者表邪较重，后者表邪较轻。而桂二越一汤则非但小邪不解，且兼有内热。临床上要详细辨证，方能得心应手，用之无误。

【方歌】

桂加麻膏量要轻，热多寒少脉不丰；

小汗法中兼清热，桂二越一记心中。

【医案选录】

刘某，女，10岁。深秋受感，迨至初冬不解，发热恶寒，每日发作数次，脉浮无力，舌质红，有薄白苔。问其二便正常，饮食尚可。辨为风寒表邪不解，寒将化热而游离于表里之间的轻证。

为疏：麻黄3克，桂枝3克，芍药3克，炙甘草3克，生姜3克，大枣4枚，生石膏6克，玉竹3克。

共服两剂，得微汗而解。

（刘渡舟医案）

九、桂枝去桂加茯苓白术汤

【药物组成】

芍药三两 甘草（炙）二两 生姜（切） 白术 茯苓各三两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上六味，以水八升，煮取二升，去滓，温服一升，小便利则愈。（本云桂枝汤，今去桂枝，加茯苓、白术。）

【适应证】

水结于中，经气阻于外，而出现头项强痛、翕翕发热、无汗、心下满微痛、小便不利等证。

【原文】

第28条。

【方义】

水气内停，使膀胱经气不利，用茯苓、白术健脾利水，芍药、大枣、甘草调和营卫，并能解除上腹部的痉挛疼痛。俾经气通畅，则诸证遂除。

【选注】

柯韵伯：“汗出不彻而遽下之，心下之水气凝结，故反无汗而外不解，心下满而微痛也。然病根在心下，而病机在膀胱。若小便利，病为在表，仍当发汗；如小便不利，病为在里，是太阳之本病，而非桂枝症未罢也，故去桂枝，而君以苓术，则姜芍即散邪行水之法，佐甘枣效培土制水之功。此水结中焦，只可利而不可散，所以与小青龙、五苓散不同法，但得膀胱水去，而太阳表里证悉除，所谓治病必求其本也。”

陈修园：“太阳之气陷于中土，心下为脾之部位，故满而微痛；脾不能转输其津液，故小便不利。今用桂枝去桂加白术、茯苓，则转输灵而小便自利。小便利而太阳之气达于内外，而内外之邪俱净矣。”

【按语】

本方去桂还是去芍，历来医家争论不休。《医宗金鉴》认为去桂当是去芍之误。成无己不去桂而加苓术，则模棱两可。陈修园、柯韵伯服膺原文，仍主去桂。我们认为：本证的病机关键在于小便不利，所以才有头项强痛、翕翕发热、无汗等证。这是膀胱停水，腑病及经，出现类似太阳经表之证。为此，去桂枝而加苓术，不在发汗而在于利小便。陈修园说：“俾小便利而太阳之气达于外，而内外之邪俱净矣。”观方后注有“小便利则愈”五字，对本方治疗目的，自可了如指掌矣。

【方歌】

桂枝汤中去桂枝，苓术加来利水湿；
小便不利心下满，头项强痛热翕翕。

【医案选录】

嘉庆戊辰，吏部谢芝田先生令亲，患头项强痛，身疼心下满，小便不利。服表药无汗，反烦，六脉洪数。初诊疑为太阳阳明合病，谛思良久，曰：前病在无形之太阳，今病在有形之太阳也。但使有形之太阳小便一利，则所有病气俱随无形之经气而汗解矣。用桂枝去桂加茯苓白术汤，一服遂瘥。

（摘《长沙方歌括》）

十、桂枝加厚朴杏子汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 甘草（炙）二两 生姜（切）三两 芍药三两 大枣（擘）十二枚 厚朴（炙去皮）二两 杏仁（去皮尖）五十枚

【煎服法】

上七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。

【适应证】

素有喘疾而病太阳中风，症见：气喘、发热、汗出、恶风、脉浮缓，或太阳病误下，表邪未解，而致微喘。

【原文】

第18条、43条。

【选注】

成无己：“下后大喘，则为里气太虚，邪气传里，正气将脱也。下后微喘，则为里气上逆，邪不能传里，犹在表也。与桂枝汤以解外，加厚朴、杏仁以下逆气”。

【按语】

今之临床治疗肺炎作喘，往往首先想到麻杏甘膏汤，对于风寒表未解，而见发热、汗出、咳喘的肺炎患者，本方常有令人满意的治疗效果，临床上切勿忽视。

【方歌】

桂加厚朴杏子仁，喘家中风妙如神；
如今肺炎求治法，媲美麻杏说与君。

【医案选录】

戊申正月，有一武弁在仪真为张遇所虏，日夕置于舟艙板下，不胜跼伏，后数日得脱。因饱食，解衣以自快，次日遂作伤寒。医者以因饱伤食而下之，一医以解衣中邪而汗，杂治数日，渐觉昏困，上喘息高。医者惶惶罔知所措。予诊之曰：太阳病下之，表未解，微喘者，桂枝加厚朴杏子汤，此仲景法也。医者争曰：某平生不曾用桂枝，况此药热，安可愈喘？予曰：非汝所知也，一投而喘定，再投而濈濈汗出，至晚，身凉而脉已和矣。

（摘许叔微《伤寒九十论》第2页）

十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 生姜四两 芍药四两 甘草（炙）二两 人参三两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上六味，以水一斗二升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今加芍药、生姜、人参。）

【适应证】

太阳病误汗，损伤营血，而身体疼痛，脉沉迟无力。

【原文】

第62条。

【方义】

桂枝汤加重芍药用量以滋营血；重用生姜之宣，使药力外走体表而止痛，增加人参益气养营而扶正。

【选注】

尤在泾：“发汗后，邪痹于外，而营虚于内，故身痛不除，而脉转沉迟。经曰：其脉沉者，营气微也。又曰：迟者，营气不足，血少故也。故以桂枝加芍药、生姜、人参以益不足之血，而散未尽之邪。东垣云：仲景于病人汗后身热亡血、脉沉迟者，下利身凉、脉微血虚者，并加人参。古人血脱者，必益气也。然人参味甘气温，温固养气，甘亦实能生血。汗下之后，血气虚衰者，非此不为功矣。”

【按语】

虚弱之人，发汗不当，可能出现伤阴和伤阳两种情况。若阳虚而汗漏不止者，则采用桂枝加附子汤；若阴血受损而身痛脉沉迟者，则用新加汤。

发汗不当，营血受伤，筋脉失养，故尔身痛。其脉由浮变沉迟，说

明表邪虽解而正气已虚，故当采用扶正之法，切忌再发虚人之汗。

【方歌】

桂枝加参新加汤，增姜加芍效力彰；
身疼脉沉非表证，血虚营弱汗多伤。

【医案选录】

曾治一樊姓妇女，新产之后，忽而身痛。自服“生化汤”两帖无效。随我实习的学员诊为气血两虚身疼，用当归、黄芪、党参、白术、甘草等药，服之有效，但治不彻底。切其脉沉缓无力，舌淡苔白，嘱用新加汤，三剂而病愈。学员不解，我解释说：关键在于新加汤走表而参芪走里，此身疼一证，是在表的营卫气血不足，故服新加汤更为合拍。

（刘渡舟医案）

十二、桂枝甘草汤

【药物组成】

枝桂（去皮）四两 甘草（炙）二两

【煎服法】

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

【适应证】

太阳病发汗过多，伤及心阳，出现叉手自冒心、心下悸、欲得按的心阳不足证。

【原文】

第64条。

【方义】

心为阳中之太阳，心阳不足，则心悸不安，故喜用手按，俾外有所护则内悸稍安。桂枝入心助阳，甘草益气补中，二药相配，辛甘合化，则有温通心阳之功。心阳得复，则诸症自愈。

【选注】

徐大椿：“发汗不误，误在过多。汗为心之液，多则心气虚。二味扶阳补中，此乃阳虚之轻者。甚而振振欲擗地，则用真武汤矣。一证而轻重不同，用方迥异，其义精矣。”

柯韵伯：“此方用桂枝为君，独任甘草为佐，以补心之阳，则汗出多者，不至于亡阳矣。姜之辛散，枣之泥滞，固非所宜。并不用芍药者，不欲其苦泄也。甘温相得，气和而悸自平，与心中悸而烦、心下有水气而悸者迥别。”

【按语】

本方药味简单，却是补助心阳的要方。凡平素心阳不足之人，稍动则气促，心悸汗出者，均可应用本方。如有水气者，可以加茯苓、白术；如阳虚至甚，出现振振欲擗地者，则用真武汤为宜。

据临床报道，本方水渍代茶，对低血压而致头晕者，效果亦佳。

【方歌】

桂枝甘草补心虚，两手叉冒已浇漓；
汗多亡液心阳弱，药少力专不须疑。

【医案选录】

某女，58岁，消瘦，体质虚弱，在冬天温暖室内仍需用被炉，如果突然把被炉拿掉，就加重心悸，坐立不安，如果不躺下就会更加痛苦。投与：桂枝末0.6克，甘草末0.3克后，心跳遂渐渐平静，而且30分钟后，还能干活。这种情况不是一次，而是数次。什么时候用桂枝甘草末，都能收到又快又好的疗效。心悸发作时，如不立即服药，不仅心悸更加厉害，还会发生呕吐。

（摘殷晓明译《汉方四临床》第25卷）

十三、小建中汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚 芍药六两 生姜（切）三两 胶饴一升

【煎服法】

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内饴，更上微火消解，温服一升，日三服。（呕家不可用建中汤，以甜故也。）

【适应证】

平素气血不足之人，感寒之后，出现心中烦悸；或少阳病，由于正气不足，土不培木，而见腹中拘急疼痛，阳脉涩，阴脉反弦者。

【原文】

第100条、102条。

【方义】

饴糖补虚养血、缓急止痛为主药。配桂枝、甘草能温中补虚；合芍药、甘草可缓急止痛；又以大枣、生姜健胃而和营卫。六药相配，使中焦之气得复，土能培木，则腹痛自止，气血得充，虚烦心悸得宁。

【选注】

成无己：“脾者，土也，应中央，处四藏之中，为中州。治中焦，生育营卫，通行津液。一有不调，则营卫失所育，津液失所行，必以此汤温建中藏，是以建中名焉。胶饴味甘温，甘草味甘平，脾欲缓，急食甘以缓之。建脾者，必以甘为主，故以胶饴为君，甘草为臣。桂枝辛热，辛散也，润也，荣卫不足，润而散之。芍药味酸微寒，酸收也，泄也，津液不逮，收而行之，是以桂芍药为佐。生姜味辛温，大枣味甘温……卫为阳，不足者益之必以辛；荣为阴，不足者补之必以甘。辛甘相合，脾胃健而荣卫通，是以姜枣为使。”

【按语】

本方实际是桂枝汤倍芍药加饴糖而成，不以桂枝加味名方，是因其重点不在于解表，而在于建中。中焦为营卫气血之源，太阳中风固然可使营卫失调，中焦虚衰同样亦可致营卫失调，而出现阴阳不和的寒热证象。小建中汤正为此证而设，它开辟了内伤甘药补虚的法门。

临床上常用本方治疗虚寒性腹痛，如消化道溃疡、肠痉挛、慢性肝炎等，凡中医辨证属虚寒者，皆可酌情使用。

【方歌】

桂加饴糖小建中，倍加芍药方奏功；
虚劳里急心烦悸，伤寒尺迟梦失精。

【医案选录】

李妇，38岁，大连人。产后失血过多，又加天气酷寒，而腹中疼痛，痛时自觉肚皮向里抽动。此时，必须用热物温暖，方能缓解。切其脉弦细而责，视其舌淡嫩苔薄。辨为血虚而不养肝，肝急而刑脾，脾主腹，是以拘急疼痛，而遇寒更甚。

为疏：桂枝10克，白芍30克，炙甘草6克，生姜9克，大枣7枚，当归10克，饴糖40克（烊化）。

此方服至三剂，而腹痛不发。转方用双和饮气血两补收功。

（刘渡舟医案）

十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 甘草（炙）二两 生姜（切）三两 大枣（擘）十二枚 牡蛎（熬）五两 蜀漆（洗去腥）三两 龙骨四两

【煎服法】

上七味，以水一斗二升，先煮蜀漆，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今去芍药，加蜀漆、牡蛎、龙骨。）

【适应证】

治疗伤寒误用火攻，损伤心阳，出现惊狂，卧起不安等证。

【原文】

第112条。

【方义】

桂枝合甘草，辛甘以扶心阳之虚；生姜配大枣，补中益气兼和营卫；龙骨、牡蛎潜镇心神，定其惊狂。夫胸阳不振，则阴霾内生，痰浊之邪可以迷心，故用蜀漆之辛劫痰以开窍。

【选注】

尤在泾：“阳者，心之阳，即神明也。亡阳者，火气通于心，神被火迫而不守。此与发汗亡阳者不同。发汗者，摇其精则厥逆、筋惕肉瞤，故当用四逆。被火者，动其神则惊狂起卧不安，故当用龙牡。其去芍药者，盖欲以甘草急复心阳，而不须酸味更益营气也。与发汗后，其人叉手自冒心，心下悸、欲得按者，用桂枝甘草汤同意。蜀漆，即常山苗，味辛，能去胸中邪结气。此证火气内迫心包，故须之以逐邪而安正耳。”

【按语】

本方即桂枝汤去芍药，再加蜀漆、龙骨、牡蛎而成。胸阳不振，如

出现胸满脉促者，用桂枝去芍药汤。若阳虚为甚，阴邪内凝，出现胸满烦惊、卧起不安等证，应以本方扶阳消阴、涤痰开窍而镇静安神。

本证由心虚烦躁发展至惊狂卧起不安，显然病情较前为重，而又有痰邪内阻之变，故此方加蜀漆，以去痰水之结，方有利于桂枝的温通，而达到治疗目的。

【方歌】

桂枝去芍恐助阴，痰水犯心狂躁纷；

龙牡安神桂枝助，蜀漆涤饮有奇勋。

【医案选录】

董某，男，28岁，包头人。因精神受刺激而成疾。自称睡眠不佳，心中烦躁，并有三幻（幻听、幻视、幻觉）症状，有时胆小害怕，有时悲泣欲哭，胸中烦闷，不能自己。切其脉弦滑，视其舌苔白腻而厚。辨为痰热内阻，上扰心宫，而肝气复抑所致。

疏方：蜀漆6克，黄连9克，大黄9克，生姜9克，桂枝6克，龙骨12克，牡蛎12克，竹茹10克，胆星10克，菖蒲9克，郁金9克。

服两剂而大便作泻，心胸为之舒畅。上方减去大黄，又服三剂，突然吐出痰涎盈碗，从此病情好转。后用涤痰汤与温胆汤交替服用而获愈。

（刘渡舟医案）

十五、桂枝加桂汤

【药物组成】

桂枝（去皮）五两 芍药三两 生姜（切）三两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今加桂满五两，所以加桂者，以能泄奔豚气也。）

【适应证】

治奔豚气，因烧针发汗，针处受寒，核起而赤，导致气从少腹上冲于心。

【原文】

第117条。

【方义】

桂枝汤解表以散外寒，加重桂枝剂量，使其平冲降逆，以泄奔豚于下。

【选注】

陈修园：“少阴上火而下水，太阳病以烧针令其汗，汗多伤心，火衰而水乘之，故发奔豚。用桂枝加桂，使桂枝得尽其量，上能保少阴之火脏，下能温少阴之水脏，一物而两扼其要也。”

徐大椿：“重加桂枝，不特御寒，且制肾气，又味重则能达下。凡奔豚证，此方可增减用之”。

【按语】

丹波元简认为：奔豚一证，多因寒水上冲，故治法不出降逆散寒的范围云云。我们认为：少阴阳虚是奔豚证的内因，外受风寒和精神刺激则是奔豚的诱因。此证气从少腹上冲心胸以外，亦可见到少腹鼓起如木棒状，兼见心下悸动、短气、急迫、起卧不安等证。若气冲至咽喉，则

有窒息欲死的恐怖之感，并可伴有出冷汗及精神极度紧张等证。

桂枝既可以疏肝解郁，又可以补心阳以降逆气。所以，加重桂枝的剂量而制大其服，则外可散寒，内可平冲，而奔豚自己。

本方是加桂枝还是加肉桂，有两种不同看法。我们认为，根据原文“更加桂二两”，应是加桂枝，然验于临床，加肉桂亦能取得疗效。

【方歌】

桂枝加桂剂量增 奔豚冲心来势凶

平冲降逆解外寒 补心伐肾立奇功

【医案选录】

崔某，女，50岁。其证颇奇，自觉有一股气流，先从两腿内侧开始，沿阴股往上滚动，至小腹则腹胀；至心胸则心悸不稳，头出冷汗，胸中憋气，精神极度紧张，有濒死恐怖感。稍呆一会儿，气往下行，症状随之减轻。每天发作三四次，兼见腰酸，白带多。患者面色青黄不泽，舌胖质嫩，苔白而润，脉弦数而无力。

辨证：此病为“奔豚气。”然从内踝上冲，而不从少腹上冲则为仅见之证。凡犯上之气，必因上虚所致，今心阳上虚而肾之阴气则得以上犯。夫阴来搏阳，虚阳被迫而与之争，故脉虽数而按则无力也，弦脉属阴，阴盛则脉弦。舌质胖嫩，亦非阳虚之象。今阴来搏阳，凡阴气所过之处，则发胀憋气，心悸不安，亦勿怪其然。治当助心阳伐阴降冲。

方用：桂枝五钱，白芍三钱，生姜三钱，炙甘草二钱，大枣七枚，另服“黑锡丹”二钱。共服五剂，其病不发而愈。

（刘渡舟医案）

十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤

【药物组成】

桂枝（去皮）一两 甘草（炙）二两 牡蛎（熬）二两 龙骨二两

【煎服法】

上四味，以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，日三服。

【适应证】

治心阳虚而烦躁不眠，或见心悸、汗出等证。

【原文】

第118条。

【方义】

本方为治心阳不足，神不潜敛而烦躁不眠。用桂枝、甘草补心阳之虚，加龙骨、牡蛎以潜敛心神。

【选注】

尤在泾：“火逆下之，已误复误，又加烧针，火气内迫，心阳内伤，则生烦躁。桂枝、甘草，以复心阳之气；牡蛎、龙骨，以安烦乱之神。”

柯韵伯：“火逆又下之，因烧针而烦躁，即惊狂之渐也。急用桂枝甘草以安神，加龙骨牡蛎以救逆。比前方（桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤）简而切当。近世治伤寒者，无火熨之法，而病伤寒者，多烦躁惊狂之变，大抵用白虎、承气辈，作有余治之。然此证属实热者固多，而属虚寒者间有，则温补安神之法不可废也。更有阳盛阴虚而见此症者，当用炙甘草汤加减，用枣仁、远志、茯苓、当归等味，又不可不知。”

【按语】

医用烧针刺病人，则精神上的紧张和惊恐是难免的。惊则心怯气乱，而使邪有可乘之机，所以本病的产生与惊恐有关。至于素有心虚神怯之证，虽不经烧针误治，亦可产生此证。正如陈修园所说：“今人不

用烧针而有火逆之证者，炮姜、桂、附、荆、防、羌、独之类逼其逆也”。他的话具有一定的指导意义。

【方歌】

桂枝甘草组成方，龙牡加入安神良；
心悸同时兼烦躁，补阳宁心效果彰。

【医案选录】

宋先生与余同住一院，时常交谈中医学术。一日，宋忽病心悸，悸甚而神不宁，坐立不安，乃邀余诊。其脉弦缓，按之无力，其舌淡而苔白。余曰：病因夜作耗神，心气虚而神不敛之所致。

乃书：桂枝9克，炙草9克，龙骨12克，牡蛎12克，凡三剂而病愈。

（刘渡舟医案）

十七、桂枝附子汤

【药物组成】

桂枝（去皮）四两 附子（炮、去皮、破）三枚 生姜（切）三两 大枣（擘）十二枚 甘草（炙）二两

【煎服法】

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

【适应证】

治风寒湿痹，身疼不能转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩。

【原文】

第174条。

【方义】

桂枝辛温，通经散风；附子大热，驱逐寒湿而扶阳止痛；甘草、生姜、大枣辛甘发散，调和营卫，而使风湿之邪从外而解。

【选注】

成无己：“不呕不渴，里无邪也。脉得浮虚而涩，身有疼痛，知风湿但在经也。与桂枝附子汤，以散表中风湿。”

尤在泾：“伤寒至八九日之久，而身疼不除，至不能转侧，知不独寒淫为患，乃风与湿相合而成疾也。不呕不渴，里无热也。脉浮虚而涩，风湿外持，而卫阳不振也。故于桂枝汤去芍药之酸寒，加附子之辛温，以振阳气而散阴邪。”

【按语】

桂枝辛温，发散风邪，更能通经活络；配以附子大热之品，温散寒湿而力大功专。甘草、生姜、大枣则调和营卫，扶正去邪，为治疗寒湿痹证的要方。

本方的药物与桂枝去芍药加附子汤同，但在剂量上却加重许多。附

子熟用而量大，则可温经止痛以治痹；生用则扶阳消阴而治厥。

【方歌】

桂枝附子寒痹痛，去芍加附量要重；
扶阳散寒应兼顾，脉浮虚涩是其应。

【医案选录】

黄某，女，24岁。下肢关节疼痛已年余，曾经中西治疗效果不显。现病情仍重，尤以右膝关节疼痛为甚，伸屈痛剧，行走困难，遇阴雨天则疼痛难忍，胃纳尚好，大便时结时烂，面色^晄白，苔白润滑，脉弦紧，重按无力，诊为寒湿痹证。

处方：桂枝尖一两，炮附子八钱，生姜六钱，炙草四钱，大枣四枚，三剂。

复诊：服药后痛减半，精神食欲转佳。

处方：桂枝尖一两，炮附子一两，生姜八钱，炙草六钱，大枣六枚。

连服十剂，疼痛完全消失。

（摘《广东医学·祖国医学版》1964，6：30）

十八、去桂加白术汤

【药物组成】

附子（炮、去皮、破）三枚 白术四两 生姜（切）三两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。初一服，其人身如痹，半日许复服之，三服都尽。其人如冒状，勿怪，此以附子、术并走皮内，逐水气未得除，故使之耳。法当加桂四两。（此本一方二法，以大便硬、小便自利，去桂也；以大便不硬、小便不利，当加桂。附子三枚恐多也，虚弱家及产妇，宜减服之。）

【适应证】

全身疼痛剧烈，转侧为之困难，不呕不渴，大便硬，小便自利，脉来浮虚而涩。

【原文】

第174条。

【方义】

炮附子温经助阳散寒，白术健脾燥湿，术附合用，并走皮间，以逐寒湿之邪。姜枣调和营卫，炙甘草和中安正。

【选注】

柯韵伯：“脉浮为在表，虚为风，涩为湿，身体烦疼，表证表脉也；不呕不渴，是里无热，故于桂枝汤加桂以治风寒。去芍药之酸寒，易附子之辛热，以除寒湿。若其人大便硬，小便自利者，表证未除，病仍在表。不是因于胃家实，而因于脾气虚矣。盖脾家实，腐秽当自去；脾家虚，湿土失职不能制水，湿气留于皮肤，故大便反见燥化。不呕不渴，是上焦之化源清，故小便自利。濡湿之地，风气常在，故风湿相搏不解也。病本在脾，法当君以白术，代桂枝以治脾，培土以胜湿，土旺则风自平矣。”

【按语】

“风寒湿三气杂至合而为痹。”本方所治为寒湿偏胜，所以术附并用。“若其人大便硬，小便自利”一句，注家意见不一，唯柯氏指出：大便溏为脾虚之常，大便硬系脾虚之变，而能一言道破病机。

本方后有“其人身如痹”、“其人如冒状”之语，这既是正气驱邪的反映，也提示了附子剂量不能再大。所以，既言“勿怪”，又说“附子三枚恐多也，虚弱家及产妇宜减服之，”其中有瞻前顾后之意。

【方歌】

去桂加术大便硬，寒湿相搏身疼痛；
术附姜枣加甘草，三服都尽冒始应。

【医案选录】

韩某，男，37岁，工人。自诉患关节炎有数年之久，右手腕关节囊肿起如蚕豆大，周身酸楚疼痛，尤以两膝关节为甚，已不能蹲立，走路很困难，每届天气变化，则身痛转剧。视其舌淡嫩而胖，苔白滑，脉弦而迟，问其大便则称干燥难解。辨为寒湿着外而脾虚不运之证。

为疏：附子15克，白术15克，生姜10克，炙甘草6克，大枣12枚。

服药后，周身如虫行皮中状，两腿膝关节出黏凉之汗甚多，而大便由难变易。

转方用：干姜10克，白术15克，茯苓12克，炙甘草6克。

服至三剂而下肢不痛，行路便利。又用上方三剂而身痛亦瘳。后以丸药调理，逐渐平安。

（刘渡舟医案）

十九、桂枝加芍药汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 芍药六两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚 生姜（切）三两

【煎服法】

上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温分三服。（本云桂枝汤，今加芍药。）

【适应证】

治太阴脾家的气血不和而发生腹满时痛等证。

【原文】

第279条。

【方义】

本方即桂枝汤原方而倍加芍药。芍药大于桂枝，则不治表而治里，故能调和脾胃气血阴阳的不和。气血通利，脾经调和，则腹满时痛等证自己。

【选注】

尤在泾：“病在太阳，不与解表，而反攻里，因而邪气乘虚陷入太阴之位，为腹满而时痛，陶氏所谓误下传者是也。夫病为邪陷而来者，必得邪解而后愈；而藏阴为药所伤者，亦必以药和之而后安，故须桂枝加芍药汤主之。桂枝所以越外入之邪，芍药所以安伤下之阴也。按‘伤寒阳脉涩、阴脉弦，法当腹中急痛者，与小建中汤；不差者，与小柴胡汤’。此亦邪陷阴中之故，而桂枝加芍药亦小建中之意，不用胶饴者，以其腹满，不欲更以甘味增满耳。”

【按语】

本病来源于太阳，经误下转入太阴，使脾脏气血不利。气滞则胀，血滞则痛，故曰“腹满时痛”。

本方为和里之剂，但有的注家囿于桂枝汤解表，认为此方解表和里，这是不妥当的。因为方中芍药倍于桂枝，阴药大于阳药，显然它已不具解表的作用了。临床应用本方，要抓住脾胃不和、气血不利和脾阴偏虚这三个病理环节，使用本方则万举万当。

气血不利的腹满，则有别于以胀为主的厚朴生姜半夏甘草人参汤证。彼则气滞而胀，此则兼有血脉不利，故既有腹胀，同时也有腹痛。

脾属土，肝属木。脾家气血不利，必然会影响及肝，而使肝木不达。脾气不和，肝来刑之，故其脉常弦。由于气血郁滞而又使脾阴不和，此与阴血不足有关，所以临床表现舌质也多偏红。

【方歌】

桂枝加芍腹痛珍，此病原来属太阴；
慢性菌痢久不已，脉沉弦缓是指针。

【医案选录】

李某，男，43岁，湖北人。患慢性菌痢已五载，大便每日七八次，里急后重，大便带有白色黏液。大便镜检：红细胞0~1，脓细胞3~5，吞噬细胞0~1。经西药治疗未能痊愈。切其脉弦，按腹肌挛如条索，舌红而苔薄白。

辨证：久利伤阴，腹痛而肌肉痉挛，脉来又弦，反映了肝脾不和，气血乖戾，疏泄失司之象。治法：调和肝脾，缓解拘急。

方药：桂枝9克，白芍18克，炙甘草6克，生姜9克，大枣12枚。

上方连服四剂，而下利悉愈。

（刘渡舟医案）

二十、桂枝加大黄汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 大黄二两 芍药六两 生姜（切）三两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

太阴病，腹满疼痛而大便不通。

【原文】

第279条、280条。

【方义】

桂枝加芍药汤，可调和脾家气血，再加大黄，又可攻逐肠胃间的腐秽之物。

【选注】

尤在泾：“腹满而未实，痛而不甚者，可以桂枝加芍药和而解之。若大实大痛者，邪气成聚，必以桂枝加大黄越陷邪而去实滞也。夫太阴脾脏也，何以能实而可下。阳明者，太阴之表，以膜相连，脏受邪而腑不行则实，故脾非自实也，因胃实而实也。大黄所以下胃，岂以下脾哉？”

【按语】

本方所指的病机，是以脾家气血不和，外累阳明，即“脏受邪而腑不行则实”的病变。

本方主证是腹满疼痛拒按，脉弦有力，舌红苔厚，大便秘结，或大便泻下不爽，或便脓血后重难通。

【方歌】

桂加大黄治腹痛，太阴阳明表里病；
调和气血泻结滞，胃弱之人宜慎用。

【医案选录】

李某，男，36岁，腹痛下利红白，里急后重，每日三四次，经年不愈，而治疗罔效。切其脉弦而任按，舌苔黄而质绛。余曰：此病脾胃气血不和，又中夹凝滞之邪，积邪不去，则下利不能止。法当通因通用，扫除肠中腐秽则病可愈。

疏：桂枝6克，白芍18克，生姜9克，炙甘草6克，大枣7枚，大黄6克。

嘱一次煎服。服药不久而大便作泻，皆黏腻臭秽之物。从此而下利日见轻缓，因此获愈。

（刘渡舟医案）

二十一、桂枝人参汤

【药物组成】

桂枝（别切）四两 甘草（炙）四两 白术三两 人参三两 干姜三两

【煎服法】

上五味，以水九升，先煮四味，取五升，内桂，更煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

【适应证】

治协热利而表里皆寒，内见腹痛泻下不止而心下痞满，外见发热恶寒而其表不解，以舌淡苔白，脉浮迟无力为准。

【原文】

第163条。

【方义】

人参、甘草补中益气，干姜温中驱寒，白术健脾燥湿，用桂枝通阳解表。后下桂，取其气薄而先解表之义。

【选注】

柯韵伯：“外热未除，是表不解；利下不止，是里不解，此之谓有表里症。然病根在心下，非辛热何能化痞而软硬？非甘温无以止利而解表。故用桂枝甘草为君，佐以干姜参术。先煎四物，后内桂枝，使和中之力饶，而解肌之气锐，于以奏双解表里之功。”

【按语】

本方与葛根黄芩黄连汤都是表里双解之剂，而有寒热补泻之别。此为表里皆寒而设，彼为表里皆热下利而立；此补太阴之里虚，彼清阳明之内热。两证对比自明，不得混为一谈。

【方歌】

人参汤方即理中，加桂后煎力方增；

痞利不解中寒甚，温中解表建奇功。

【医案选录】

刘君利病复作，投当归银花汤，另送伊家制利疾散茶二包，病虽愈，唯便后白色未减，心下痞硬，身热不退。愚思仲景曰：太阳病，外证未除而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之。遂书此以服，大效。后因至衡州取账目，途中饮食不洁，寒暑失宜，病复大作，遂于衡邑将原方续服三剂乃愈。

（摘《中医杂志》谢安之医案）

麻黄汤类概述

麻黄汤类共八方，一是麻黄汤，是发散太阳经表寒邪而设。其证候表现以无汗、恶寒、发热、头身疼痛、气喘等证为主。二是大青龙汤，是外散风寒，兼清阳郁的主方，其证候表现以伤寒不汗出而烦躁为主。三是小青龙汤，是治外寒内饮的主方，其证候表现以咳而发热，或见气喘等证为主。四是麻黄杏仁甘草石膏汤，是清肺平喘的主方，其证候表现以汗出而喘、身热等证为主。五是麻黄连轺赤小豆汤，是外散瘀热，内利湿邪的主方，其证候表现以脉浮、发热、恶寒、一身面目悉黄为主。六是麻黄细辛附子汤，是温经散寒的主方，其证候表现以发热而脉反沉为主。七是麻黄附子甘草汤，是在麻黄细辛附子汤证的前提下，其病已过两三日，此时虽无表证，但正气已虚，故于上方减细辛之散，而加甘草之补。八是麻黄升麻汤，是宣发阳郁之邪，而又上滋肺阴，下温脾阳的主方，其证候表现以寸脉沉迟，下部脉不至，手足厥冷，咽喉不利，吐脓血，泄利不止等证为主。

上述麻黄汤加减八方，从其加石膏则清热，加附子则温寒，加赤小豆、梓皮则利湿，加葳蕤、天冬则生津滋燥，可见麻黄方之变化多端，固不拘于发汗散风寒之一格。若能师其法而推广其义，则又非八方所能尽矣。

一、麻黄汤

【药物组成】

麻黄（去节）三两 桂枝（去皮）二两 甘草（炙）一两 杏仁（去皮尖）七十个

【煎服法】

上四味，以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

【适应证】

（一）治太阳病伤寒，头痛发热、身疼腰痛、骨节疼痛、恶风寒、无汗而喘，脉浮紧等证。

（二）治太阳伤寒，失于发汗，鼻衄不畅等证。

（三）治太阳阳明合病，不大便，气喘胸满而表证偏重之证。

【原文】

第35条、36条、37条、46条、51条、52条、55条、232条、235条。

【方义】

本方为辛温发汗之峻剂。方以麻黄为君，既能解表发汗以散风寒，又能宣利肺气而治气喘。辅以桂枝辛温通阳，可助麻黄解肌发汗，又可温通血脉以解疼痛。杏仁宣肺降气，协麻黄止咳平喘。炙甘草调和诸药，而守中养正。

【选注】

徐大椿：“此痛处比桂枝证尤多而重，因营卫俱伤故也。恶风无汗而喘者，乃肺气不舒之故。麻黄治无汗，杏仁治喘，桂枝、甘草治太阳诸证，不一味不紧切，所以谓之经方。”

柯韵伯：“余治冷风哮与风寒湿三气成痹等证，用此辄效。”

【按语】

本方为太阳表实证而设。其病机为寒邪外束，卫闭营滞，所以出现无汗和诸种疼痛。是方宣通卫气，畅达营阴，使寒从汗出，则发热恶寒自解。一般称之为“麻黄八证”，即头痛、发热、身疼、腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗、气喘。其中疼痛占半，可见此方擅治风寒疼痛，且有宣肺平喘之效，而不可不知。

还应当指出，妇人难产，由于表寒不解，使营卫闭塞不畅，服用本方散寒利营，即可顺利分娩。

本方麻黄的剂量应大于桂枝、甘草，否则，将不能起到发汗解表的作用。尤在泾曰：“桂枝甘草，虽曰佐之，实以监之”。说明桂枝甘草有监制麻黄发汗的作用，所以，若麻黄量小而桂甘量大，则就失去了它发汗解表的意义。

本方先煎麻黄去上沫，以免发烦。张锡驹说：“其沫中含有发表之猛力，”可见去沫之举，亦不可忽视。

【方歌】

麻黄汤治太阳寒，麻桂杏草四药联；
表实无汗头身痛，脉紧气喘更恶寒。

【医案选录】

有豪子病伤寒，脉浮而长，喘而胸满，身热头疼，腰脊强，鼻干不得眠。予曰：太阳阳明合病证，仲景法中有三证，下利者葛根汤；不下利呕逆者加半夏；喘而胸满者麻黄汤也。治以麻黄汤，得汗而解。

（摘《伤寒九十论》证八十四）

二、大青龙汤

【药物组成】

麻黄（去节）六两 桂枝（去皮）二两 甘草（炙）二两 杏仁（去皮尖）四十枚 生姜（切）三两 大枣（擘）十枚 石膏（碎）如鸡子大

【煎服法】

上七味，以水九升，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。汗出多者，温粉粉之。一服汗者停后服。若复服，汗多亡阳，遂虚恶风，烦躁不得眠也。

【适应证】

太阳病表邪实不汗出而发生烦躁，或不汗出而身不疼但重，乍有轻时。

【原文】

第38条、39条。

【方义】

本方为麻黄汤倍麻黄加石膏、生姜、大枣而成。倍用麻黄，配以生姜、桂枝、杏仁加强发汗之力，以解风寒闭郁之邪；加石膏以清阳郁之热而除烦躁；用甘草、大枣则有扶正去邪，调和营卫之功。

【选注】

柯韵伯：“盖仲景凭脉辨证，只审虚实，故不论中风伤寒，脉之缓紧，但于指下有力者为实，脉弱无力者为虚；不出而烦躁者为实，汗出多而烦躁者为虚；证在太阳而烦躁者为实，证在少阴而烦躁者为虚。实者可服大青龙，虚者便不可服，此最易知也。凡先烦不躁而脉浮者，必有汗而自解；烦躁而脉浮紧者，必无汗而不解。大青龙汤为风寒在表而兼热中者设，不是为有表无里而设，故中风无汗烦躁者可用，伤寒而无汗烦躁者亦可用。盖风寒本是一气，故汤剂可以互投……大青龙之点睛，在无汗烦躁、无少阴证二句。合观之，知本方本为太阳烦躁而设。”

【按语】

烦躁一证，应当具体加以分析。本证的烦躁，是表实不解，阳气内郁，郁而化热的结果，它和阳明热证的烦躁而兼有烦渴者不同。柯韵伯称之为太阳经的烦躁，因为麻黄配石膏正是为了解决这类烦躁而设的药物。程应旆说：“寒得麻黄之辛热而外出，热得石膏而内解，龙升雨降，郁热顿除”。

本方是发汗的峻烈之剂，一定要控制使用。凡阳气不足，表虚有汗，脉象微弱者，一律禁用。

还应指出，本方发汗解表，且有杏仁宣肺利气，故又能发散水气之邪而从汗解。《金匱》用治饮水流行，归于四肢的“溢饮”证，乃是本方治疗的另一个方面。

【方歌】

大青麻杏石膏枣，桂姜相加七味好；
不汗烦躁身疼痛，饮流四肢肿胀讨。

【医案选录】

石某，男，36岁。河港大队四小队社员。1965年11月3日初诊。病已三日，恶寒高热39.5℃，无汗烦躁，头身均痛，脉浮数，舌苔薄白。

处方：麻黄、桂枝各一钱半，杏仁三钱，生石膏一两，生甘草一钱，竹茹一钱半，竹叶三十片，鲜芦根二尺。水煎服。

一剂后，寒热即退，但增咳嗽。原方去桂枝，加桔梗、桑叶各一钱半。又服一剂，病即告愈。

（摘《中医杂志》1966，3：23）

三、小青龙汤

【药物组成】

麻黄（去节） 芍药 细辛 干姜 甘草（炙） 桂枝（去皮） 各三两 五味子半升 半夏（洗）半升

【煎服法】

上八味，以水一斗，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

【加减法】

若渴，去半夏，加栝蒌根三两；若微利，去麻黄，加薤白如鸡子，熬令赤色；若噎者，去麻黄，加附子一枚炮；若小便不利，少腹满者，去麻黄，加茯苓四两；若喘，去麻黄，加杏仁半升去皮尖。

【适应证】

发热恶寒，咳嗽或喘，吐清稀冷痰或白泡沫痰，舌苔水滑，脉弦或浮弦。

【原文】

第40条、41条。

【方义】

本方为外寒引动内饮而设。麻桂解表散寒，宣肺以平咳喘；芍药、桂枝调和营卫；干姜、细辛、半夏温化寒饮而散寒降逆；五味子敛肺止咳，并可内护肝肾之阴；甘草补正和诸药。共成温肺散寒、化饮止咳平喘之功。

【选注】

成无己：“伤寒表不解，心下有水饮，则水寒相搏，肺寒气逆，故干呕发热而咳。《针经》曰：形寒饮冷则伤肺，以其两寒相感，中外皆伤，故气逆而上行，此之谓也。与小青龙汤发汗散水。水气内渍，则所传不一，故有或为之证，随证增损，以解化之。”

尤在泾：“大青龙合麻桂而加石膏，能发邪气除烦躁。小青龙无石膏，有半夏、干姜、芍药、细辛、五味，能散寒邪行水饮。而谓之青龙者，以其有发汗蠲饮之功。夫热闭于经，而不用石膏，汗为热隔，宁有能发之者乎？饮伏于内，而不用姜夏，寒与饮搏，宁有能散之者乎？其芍药、五味，不特收逆气而安肺气，抑以制麻桂姜辛之势，使不相惊而相就，以成内外协济之功耳。”

【按语】

本方为素有水饮停留，复感风寒，外邪引动内饮，即所谓“两寒相感，中外皆伤”。本方重在温化寒饮，所以，不论有无表证，只要有咳嗽气喘、痰冷而稀、舌苔水滑、恶寒背冷、脉浮弦或弦者，即可应用。

方中的干姜、细辛、五味子，被认为是仲景用治寒饮不可缺少之品。临床上若肺寒偏重，则细辛、干姜用量要大于五味子；若久咳肺虚，则五味子的用量就要酌情加重；若喉中如水鸡声者，可加射干、紫菀、冬花；有热烦躁者，亦可酌加石膏。

小青龙汤是效果可靠的止咳平喘剂。我们认为：它毕竟是为发汗散寒而设，若下虚之人误用本方，则能引起冲气上逆，可出现手足厥逆、气从少腹上冲胸咽、手足痹、其面翕热如醉状，应当引起我们的注意。所以，本方不可久服，恐伐肾根，以俟证情有所缓解，即以苓桂术甘剂调理善后而为妥。

【方歌】

小青龙汤用麻黄，桂芍辛味与干姜；
半夏炙草同剂量，表寒里饮病为殃。

【医案选录】

王某，男，54岁。患咳嗽已十余载，往年冬发夏愈，自今年起，由春及夏，频发无度。现值盛夏，尚穿棉袄，夜睡棉被，凛凛恶寒，背部尤甚，咳吐稀痰，盈杯盈碗，气喘不能平卧，舌苔白，脉弦紧。此为风寒外束，饮邪内停，阻遏阳气，肺气失宣，法宜温肺化饮，解表通阳。处方：炙麻黄十一钱，桂枝三钱，姜半夏三钱，五味子一钱，干姜一钱半，白芍三钱，细辛六分，白术三钱，炙甘草一钱。

二诊时，咳嗽已稀，已弃棉衣，畏寒亦减。原方干姜加重至二钱，细辛加重至一钱。

三诊，喘咳全平，已能穿单衣，睡席子，夜寐通宵。原方再服三

剂。

四诊，诸证悉减，唯动则气喘。初病在肺，久必及肾，配以都气丸常服，以图根除。

（摘《江苏中医》1965，10：22）

四、麻黄杏仁甘草石膏汤

【药物组成】

麻黄（去节）四两 杏仁（去皮尖）五十个 甘草（炙）二两 石膏（碎，绵裹）半斤

【煎服法】

上四味，以水七升，煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。

【适应证】

气喘为甚，发热而不恶寒，汗出而口不渴，脉数，舌红，苔则薄黄。

【原文】

第63条、162条。

【方义】

本方治疗肺热气喘之证。用麻黄宣肺平喘，辅以石膏则清肺热，两药合作，而喘自止。配杏仁利肺气，以助麻黄之宣，佐甘草扶中州而调和诸药。

【选注】

尤在泾：“发汗后，汗出而喘，无大热者，其邪不在肌腠，而入肺中。缘邪气外闭之时，肺中已自蕴热。发汗之后，其邪不从汗而出之表者，必从内而并于肺耳，故以麻黄、杏仁之辛而入肺者，利肺气、散邪气；甘草之甘平，石膏之甘辛而寒者，益肺气、除热气，而桂枝不可更行矣。盖肺中之邪，非麻黄杏仁不能发，而寒郁之热，非石膏不能除；甘草不特救肺气之困，抑以缓石膏之悍也。”

【按语】

本方清宣肺气之热，效果是十分理想的。方用麻黄之目的，不在发汗，而在宣肺清热，故有汗者可用，无汗者亦可用。

本方具有显著的止咳平喘的疗效，临床常用于肺炎及小儿麻疹合并肺炎等证。如加蒲公英、双花、鱼腥草等物，则有解毒消炎的作用；若加羚羊角粉，可治小儿麻疹续发的高热而喘之证；若痰热盛者，亦可酌加黛蛤散、甜葶苈、鲜杷叶等；若大便不利，气喘而急者，可加瓜蒌皮、葶苈子、炙桑皮等清泻肺热之品；若大便燥结，腑气不利，喘而腹满者，亦可酌加牵牛、大黄泻下。

【方歌】

麻杏石甘四物施，汗出而喘肺热居；
身热脉数证方是，不恶寒兮别桂枝。

【医案选录】

钟右，住圣母院路，初诊十一月初三日。伤寒七日，发热无汗，微恶寒，一身尽疼，咯痰不畅，肺气闭塞使然也。痰色黄，中已化热，宜麻黄杏仁甘草石膏汤加浮萍。

净麻黄三钱，光杏仁五钱，生石膏四钱，青黛四分同打，生草三钱，浮萍三钱。

二诊十一月初四日：昨进麻杏石甘汤加浮萍，汗泄而热稍除，唯咳嗽、咯痰不畅，引胸腹而俱痛，脉仍浮紧，仍宜前法以泄之。

自服第二方后，又出微汗，身热全除，但胸背腹部尚有微痛，浮移不居。又越一日，病乃全瘥，起床如常人。

（摘自《经方实验录》第24页）

五、麻黄连轺赤小豆汤

【药物组成】

麻黄（去节）二两 连轺（连翘根）二两 杏仁（去皮尖）四十个 赤小豆一升 大枣（擘）十二枚 生梓白皮（切）一升 生姜（切）二两 甘草（炙）二两

【煎服法】

上八味，以潦水一斗，先煮麻黄再沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服，半日服尽。

【适应证】

身目发黄，小便不利，胸脘痞闷，发热恶寒，无汗，脉浮。

【原文】

第262条。

【方义】

麻黄、杏仁、生姜以宣散表邪；连轺、赤小豆、生梓白皮清热利湿，并有解毒之功；甘草、大枣调和脾胃。共为解表散邪、清利湿热之剂。

【选注】

《医宗金鉴》：“湿热发黄无表里证，热盛者清之，小便不利者利之，里实者下之，表实者汗之，皆无非为病求去路也。用麻黄汤以开其表，使黄从外散，去桂枝者，避其热也；佐姜枣者，和其营卫也；加连轺、梓皮以泻其热，赤小豆以利其湿，共成治表实发黄之效也。连轺，即连翘根，无梓皮以茵陈代之。”

尤在泾：“瘀热在里者，汗不得出而热瘀于里也，故与麻黄、杏仁、生姜之辛温，以发越其表；赤小豆、连轺、梓白皮之苦寒甘，以清热于里；大枣、甘草甘温悦脾，以为散湿驱邪之用；用潦水者，取其味薄，不助水气也。合而言之，茵陈蒿汤是下热之剂，栀子柏皮汤是清热之剂，麻黄连轺赤小豆汤是散热之剂也。”

【按语】

本方治疗湿热兼有表证的发黄。方中虽用发汗之剂，但佐以清热利湿之品。近人樊天徒氏认为其治疗疮毒内攻，浮肿喘满症亦有卓效，录之可作参考。

【方歌】

麻黄连轺赤豆汤，湿热兼表身发黄；
麻翘姜草梓皮枣，杏仁赤豆煮潦浆。

【医案选录】

某生，周身泛起皮疹苦痒，用手搔痒则缕缕成痕而高出皮面。举凡疏风清热利湿之药尝之殆遍而不效。切其脉浮弦，舌苔白而略腻。辨为湿热在表，阳气怫郁不伸之证。疏麻黄连轺赤小豆汤原方，服后令微汗而瘥。

（刘渡舟医案）

六、麻黄细辛附子汤

【药物组成】

麻黄（去节）二两 细辛二两 附子（炮、去皮、破八片）一枚

【煎服法】

上三味，以水一斗，先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

发热恶寒，寒多热少，头痛无汗，脉不浮而反沉，舌淡苔薄白。

【原文】

第301条。

【方义】

麻黄发汗以解太阳之表，附子补阳以扶少阴之虚，细辛散寒破阴，以助麻附散寒之用。三药相合，于扶阳之中促进解表，于解表中又能温经助阳，以达成温经解表的功效。

【选注】

成无己：“少阴病，当无热恶寒。反发热者，邪在表也。虽脉沉，以始得则邪气未深，亦当温剂发汗以散之。”

尤在泾：“此寒中少阴之经，而复外连太阳之证，以少阴与太阳为表里，其气相通故也。少阴始得本无热，而外连太阳则反发热。阳病脉当浮而紧，少阴则脉不浮而沉，故与附子、细辛，专温少阴之经；麻黄兼发太阳之表，乃少阴经温经散寒，表里兼治之法也。”

【按语】

本方所主系太少“两感”证，所以此方表里同治。但应注意，此证既有少阴里虚，而又见太阳表实，反映邪未全陷少阴，故与单纯的少阴寒证不同。若服汤后而病不瘳，则阳虚抗邪无力，不能拒邪外出，故当先救其里，则用四逆汤方。

【方歌】

麻黄附子细辛汤，太少两感用此方；
发热恶寒脉不起，温经解表有专长。

【医案选录】

男性，30余。患感冒咳嗽，迁延未愈。曾服西药和中药，咳嗽不能止，肺部透视无异常。经服药一月，咳嗽仍不好，来我处就医。体温37.5℃，喉痒咳嗽，痰白而稀量少，神形憔悴，声微嘶，困倦嗜卧，舌淡有薄润白苔，脉沉弦而尺部独浮。据脉证分析，当是风寒入于少阴。虽然不是“少阴病始得之”的证候，但它是少阴病的见证则无疑义。《张氏医通》说：“暴哑声不出，咽痛异常，卒然而起，或欲咳不能咳，或无痰，或清痰上溢，脉多沉紧，或数疾无伦，此大寒犯肾也，麻黄附子细辛汤温之，并以蜜制附子噙之，慎不可轻用寒凉之剂”。于是乎，用麻黄附子细辛汤方，给服二剂，微热退清，咳止声扬。原方出入，兼予调理，体力康复。

（摘《江苏中医》1959，2：12）

七、麻黄附子甘草汤

【药物组成】

麻黄（去节）二两 甘草（炙）二两 附子（炮去皮、破八片）一枚

【煎服法】

上三味，以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

上述之少阴病“两感证”，已二三日，而无下利吐逆等里证者。

【原文】

第302条。

【方义】

本方即麻黄附子细辛汤去细辛加炙甘草而成。因病已二三日，虽无里证，但正虚可虑，故去细辛以防伤正，加炙草以顾护正气。

【选注】

《医宗金鉴》：“此详上条少阴病得之二三日，仍脉沉发热不解者，宜麻黄附子甘草汤微发其汗也。盖谓二三日不见吐利里寒之证，知邪已衰。然热仍在外，尚当汗之，但不可过耳！故不用细辛而用甘草，盖于温散之中有和意也。此二证，皆未曰无汗，非仲景略之也，以阴不得有汗，不须言也。柯琴曰：彼太阳而脉反沉，便用四逆以急救其里，是里寒阴盛也。此少阴脉而表反热，便于表剂中加附子以预固其阳，是表热阳衰也。夫以发热无汗，太阳之表；脉沉但欲寐，少阴之里。设用麻黄开腠理，细辛散浮热，而无附子以固元阳，则太阳之微阳外亡，唯附子与麻黄并用，则寒邪散而阳不亡。此里病及表，脉沉而当发汗者，与病在表，脉浮而发汗者径庭也。若表微热，则受寒亦轻，故以甘草易细辛而微发其汗。甘以缓之，与辛以散之者又少间矣。”

【按语】

本方与麻黄附子细辛汤互相发明，虽同为温经解表、表里兼治之剂，但所主之证又有缓急轻重之分，故用药亦有加减变化之别。

【方歌】

麻黄附子甘草汤，伤寒两感阳气伤；
此方原来无里证，助阳发汗保安康。

【医案选录】

余尝治上海电报局高君之公子，年五龄。身无热，亦不恶寒，二便如常，但欲寐，强呼之醒与之食，食已，又呼呼睡去。按其脉微细无力。余曰：此仲景先圣所谓“少阴之为病，脉微细，但欲寐也”。顾余知治之之方，尚不敢必治之之验，请另乞诊于高明。高君自明西医理，能注射强心针，顾又知强心针仅能取效于一时，非根本之图，强请立方。余不获已，书：熟附片八分、净麻黄一钱、炙甘草一钱与之。又恐其食而不化，略加六神曲、炒麦芽等消食健脾之品。次日复诊，脉略起，睡时略减，当于原方加减。五日而痧疹出，微汗与俱，疹密布周身，稠逾其他痧孩。痧布达五日之久，而胸闷不除，大热不减，当于麻杏甘石重剂，始获痊愈。一月后，高公子又以微感风寒，复发嗜寐之恙，脉转微细，与前度仿佛。此时，余已成竹在胸，不虞其变，依然以麻黄附子甘草汤轻剂与之，四月而蒺。

（摘《经方实验录》第49页）

八、麻黄升麻汤

【药物组成】

麻黄（去节）二两半 升麻一两一分 当归一两一分 知母十八铢 黄芩十八铢 萎蕤（一作菖蒲）十八铢 芍药六铢 天门冬（去心）六铢 桂枝（去皮）六铢 茯苓六铢 甘草（炙）六铢 石膏（碎，绵裹）六铢 白术六铢 干姜六铢

【煎服法】

上十四味，以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服。相去如炊三斗米顷，令尽，汗出愈。

【适应证】

治咽喉不利，吐脓血，泄利不止，无汗，手足厥逆，寸脉沉迟，下部脉不至。

【原文】

第357条。

【方义】

麻黄、升麻发越误下内郁之阳邪，为方中之主药；黄芩、石膏、知母清肺胃之热；天门冬、萎蕤、当归、芍药育阴养血，以防发汗劫阴之弊；桂枝、干姜温阳以治下利；白术、茯苓、甘草补脾气以扶正虚。本方发越阳郁之邪以外出，又能育阴以清上热，温脾而治中寒。虽为补泻兼施、寒热并用之法，但偏重于升发邪气为主，故以麻黄升麻名汤。

【选注】

《医宗金鉴》：“下寒上热，若无表证，当以黄连汤为法，今有表证，故立此方，以示随证消息之治也。升麻、萎蕤、黄芩、石膏、知母、天冬，乃升举走上清热之品，用以避下寒，且以滋上也；麻黄、桂枝、干姜、当归、白芍、白术、茯苓、甘草，乃辛甘走外温散之品，用以远上热，且以和内也。分温三服令尽，汗出愈，其意在缓而正不伤，彻邪而尽除也。脉虽寸脉沉迟，尺脉不至，证虽手足厥逆，下利不止，

究其原非纯阴寒邪，故兼咽喉痛、唾脓血之证，是寒热混淆、阴阳错杂之病，皆因大下夺中所变。故仲景用此汤，以去邪为主，邪去而正自安也”。

尤在泾：“伤寒六七日，寒已变热而未实也。乃大下之后，阴气遂虚，阳气乃陷，故寸脉沉而迟。阴气虚，故下部脉不至。阴阳并伤，不相顺接，则手足厥逆。而阳邪之内入者，方上淫而下溢，为咽喉不利，为吐脓血，为泄利不止，是阴阳上下并受其病，而虚实冷热亦复混淆不清矣。是以欲治其阴，必伤其阳，欲补其虚，必碍其实，故曰此为难治。麻黄升麻汤合补泻寒热为剂，使相助而不相悖，庶几各行其是，而并呈其效。方用麻黄、升麻，所以引阳气发阳邪也，而得当归、知母、萎蕤、天冬之润，则肺气已滋，而不蒙其发越之害矣。桂枝、干姜，所以通脉止厥也，而得黄芩、石膏之寒，则中气已和，而不被其燥热之烈矣。其芍药、甘草、茯苓、白术则不特止其泄利，抑以安中益气，以为通上下、和阴阳之用耳。”

【按语】

柯韵伯、丹波氏及山田氏等人怀疑非仲景之方。他们认为：寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，泄利不止及咽喉不利、唾脓血等证，已是下厥上竭、阴阳离决之候，因断言“此证此脉，急用参附以回阳，尚恐不救，以治阳实之品，治亡阳之证，是操戈下石”。我们认为：本方所主，是伤寒误下之后，阴阳两伤而又上热下寒。阳气并于上，则有咽喉不利、吐脓血的热证；脾气因虚而下夺，则有泄利不止的虚寒之证；寸脉沉而迟、手足厥逆、下部脉不至，是阴阳错乱，阳气郁而不伸之象。虽然亦有下后伤正的问题，但决非阳气竭绝之候。同时，本证兼有火热之邪内踞于上的咽喉症状，所以辨证用药决不能执定在寒热一个侧面上。

仲景治寒热错杂证，归纳起来有四：乌梅丸寒热并用，但偏于酸收，治疗蛔厥、久利寒热错杂之证；干姜黄芩黄连人参汤寒热并用，但偏于苦降，治疗寒热吐逆之证；半夏泻心汤、黄连汤的寒热并用，皆在于调和中气，治心下痞等证；麻黄升麻汤的寒热并用，却偏于升散阳郁之邪为其特点。

本方药味较多，组方又比较复杂，然而选择的药物及用量大小，却颇具分寸，值得我们进一步研究。

【方歌】

麻黄升麻桂芍姜，知膏天冬苓术黄；

归藁炙草十四味，寒热并用和阴阳。

【医案选录】

李梦如子，曾二次患喉痰，一次患溏泄，治之愈。今复患寒热病，历十余日不退，邀余诊。切脉未竟，已下利二次，头痛、腹痛、骨节痛，喉头尽白而腐，吐脓样痰挟血，六脉浮、中两按皆无，重按亦微缓，不能辨其至次，口渴需水，小便少，两足少阴病似有似无。诊毕无法立方，且不明其病理，连拟排脓汤、黄连阿胶汤、苦酒汤，皆不惬意。复拟干姜黄连黄芩人参汤，终觉未妥。又改拟小柴胡汤加减，以求稳妥。继因雨阻，寓李宅附近，然沉思不得寐，复讯李父：病人曾出汗几次？曰：始终无汗。曾服下剂否？曰：曾服泻盐三次，而至水泻频仍，脉忽变阴。余曰：得之矣，此麻黄升麻汤证也。病人脉弱易动，素有喉痰，是下虚上热体质，新患太阳伤寒而误下之，表邪不退，外热内陷，触动喉痰旧疾，故喉间白腐，脓血交并。脾弱湿重之体，复因大下而成水泻，水走大肠，故小便不利。上焦热盛，故口渴。表邪未退，故寒热头痛、骨节痛各证仍在。热闭于内，故四肢厥冷。大下之后，气血奔集于里，故阳脉沉弱。水液趋于下部，故阴脉亦闭歇。本方组织，有桂枝汤加麻黄，所以解表发汗；有苓、术、干姜化水，利小便，所以止利；用当归助其行血通脉；用黄芩、知母、石膏以消炎清热，兼生津液；用升麻解咽喉之毒；用玉竹以祛脓血；用天冬以清利痰脓；明日即可照服此方。李终疑脉有败征，恐不胜麻桂之温，欲加丽参。余曰：脉沉弱肢冷，是阳郁，非阳虚也，加参转虑掣消炎解毒之肘，不如勿用。经方以不加减为贵也，后果愈。

（摘《伤寒论释译》第1036页）

葛根汤类概述

葛根汤类共三方，即葛根汤、葛根加半夏汤、葛根黄芩黄连汤。葛根汤治太阳伤寒无汗、项背强几几，又治二阳合病的必自下利，以及缘缘面赤、额头作痛、发热恶寒的阳明经证。葛根加半夏汤，治二阳合病，不下利但呕的胃气上逆证。葛根黄芩黄连汤则治三表七里的协热下利与喘而汗出等证。由此而论，葛根汤治下利，功在于升；加半夏治呕，既升而又降；加芩连治协热利，则又功在于清。

一、葛根汤

【药物组成】

葛根四两 麻黄（去节）三两 桂枝（去皮）二两 生姜（切）三两 甘草（炙）二两 芍药二两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。余如桂枝法将息及禁忌，诸汤皆仿此。

【适应证】

太阳病，头痛、项背强几几、无汗恶风；或二阳合病，下利而脉浮长。

【原文】

第31条、32条。

【方义】

本方治太阳表实兼有经输不利的项背强^{凡凡}证。葛根善行经输，能升腾津液、滋润筋脉，又能解肌祛邪外出；麻桂解表发汗，协葛根以解表邪；桂芍调和营卫，并助葛根以通利经输；姜、枣、草则益中焦而调和营卫。

【选注】

柯韵伯：“此方比麻黄青龙之剂较轻。然^{凡凡}更甚于项强，而无汗不失于表实，脉浮不紧数，是中于鼓动之阳风，故以桂枝汤为主，而加麻葛以攻其表实也。葛根味甘气凉，能起阴气而生津液，滋筋脉而舒其牵引，故以为君。麻黄、生姜能开玄府腠理之闭塞，祛风而出汗，故以为臣。寒热俱轻，故少佐桂芍，同甘枣以和里。此于麻桂二方之间衡其轻重，而为调和表里之剂也。故用之以治表实而外邪自解，不必治里虚而下利自瘳，与大青龙治表里俱实者异矣。”

【按语】

本方专治太阳病而兼项背强^{凡凡}。这是风寒客入太阳经输，而津液又不得濡润筋脉所致。用桂枝汤加麻黄发汗散邪，又不致汗出太多而伤津液；加葛根利经脉之凝结，使津液敷布以解除项背强急的证候。现代医学研究证明：葛根有扩张血管、促进血流的作用，这与祖国医学用治项背强急之理而遥相呼应。

本方与桂枝加葛根汤相比，彼为表虚自汗，故减麻黄；此为表实无汗，故加麻黄。本方用桂枝汤而不用麻黄汤，有调和血脉之意在内。服本方后，脊背可发生热感，继而汗出，这是药力走于经输，使经气通达、邪气外出的表现。

【方歌】

葛根桂枝加葛黄，无汗项背^{凡凡}强；二阳合病下利治，刚痉无汗角弓张。

【医案选录】

陈某，男，49岁，商业。于1957年10月20日初诊。其证颈项肩背酸痛，拘急不能转侧。病起仓猝，实证为多。处方：葛根二钱，麻黄六分，桂枝六分，白芍三钱，生甘草钱半，生姜三钱，大枣六枚，一剂痊愈。为巩固疗效，续服一剂。

（摘《浙江中医杂志》1959，3：11）

二、葛根加半夏汤

【药物组成】

葛根四两 麻黄（去节）三两 甘草（炙）二两 芍药二两 桂枝（去皮）二两 生姜（切）二两 半夏（洗）半升 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上八味，以水一斗，先煮葛根、麻黄减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。

【适应证】

太阳与阳明合病，而有发热恶寒以及缘缘面赤、额头作痛的证候，然如不下利，则见胃气上逆的呕吐证候。

【原文】

第33条。

【方义】

用葛根汤解二阳在经之邪，加半夏和胃降逆以止呕吐。

【选注】

成无己：“邪气外甚，阳不主里，里气不和，气下而不上者，但下利而不呕；里气上逆而不下者，但呕而不下利，与葛根汤以散其邪，加半夏以下逆气。”

尤在泾：“夫邪盛于外而之内者，仍当先治其邪。葛根汤合用桂枝、麻黄而加葛根，所以解经中两阳相合之邪。其不下利而但呕者，则加半夏以下逆气。而葛根汤解外，法所不易矣。”

【按语】

呕逆虽为内证，仍为经邪不解所致。根据“从外之内治其外”的原则，故本方以葛根汤发汗治其外，加半夏和其内。外解里和，其证自愈。

【方歌】

葛根加夏病二阳，下利呕逆表邪强；
疏表解肌和肠胃，合病治法好思量。

【医案选录】

程女，25岁，未婚。初春寒风料峭，因患感冒，头痛面赤，畏恶风寒，发热呕吐，脉浮而苔白润。辨证：阳明经受风寒之袭，引发胃气上逆之证。

疏方：葛根12克，麻黄6克，桂枝6克，生姜9克，半夏9克，炙甘草6克，白芍6克，大枣7枚。

服两剂，汗出身凉，呕吐不发而愈。

（刘渡舟医案）

三、葛根黄芩黄连汤

【药物组成】

葛根半斤 甘草（炙）二两 黄芩三两 黄连三两

【煎服法】

上四味，以水八升，先煮葛根减二升，内诸药，煮取二升，去滓，分温再服。

【适应证】

下利为甚，大便稠黏，气味臭秽，肛门灼热，并伴有发热、喘而汗出、腹痛、尿黄、脉数等证。

【原文】

第34条。

【方义】

葛根辛甘凉，解肌清热，并能升津止利；黄芩苦寒而清肠热；黄连味苦，能坚阴液、厚肠胃以止下利；甘草甘温，和胃安中，又能调和诸药。此方为表里双解，清热止利之剂。

【选注】

《医宗金鉴》：“太阳病桂枝证，宜以桂枝解肌，而医反下之，利遂不止者，是误下，遂协表热陷入而利不止也。若表未解，而脉缓无力，即有下利而喘之里证，法当以桂枝人参汤以治利，或从桂枝加杏子厚朴汤以治喘矣。今下利不止，脉促有力，汗出而喘，表虽未解，而不恶寒，是热已陷阳明，即有桂枝之表，亦当从葛根黄芩黄连汤主治也。方中四倍葛根以为君，芩连甘草为之佐，其意专解阳明之肌表，兼清胃中之里热，此清解中兼解表里法也。”

尤在泾：“太阳中风发热，本当桂枝解表，而反下之，里虚邪入，利遂不止，其脉则促，其证则喘而汗出。夫促为阳盛，脉促者，知表未解也；无汗而喘为寒在表，喘而汗出为热在里也。是其邪陷于里者十之七，而留于表者十之三。其病为表里并受之病，故其法亦宜表里两解之

法。葛根黄芩黄连汤，葛根解肌于表，芩连清热于里，甘草则合表里而并和之耳。”

【按语】

葛根汤证与葛根芩连汤证均为表里同病之下利，但葛根汤以表证为主，葛根芩连汤则以里证为主。又，论中的桂枝人参汤与葛根芩连汤，皆为表邪不解的协热下利而设，但前者为表里皆寒，而后者则为表里俱热，临床选方当予区别。

【方歌】

葛根芩连加甘草，协热下利喘汗宝；
清热生津解表里，葛根用至八钱好。

【医案选录】

葛根芩连汤治疗急性细菌性痢疾40例临床分析：40例中，痢下赤白者38例，里急后重者39例，40例均有腹痛，发热者34例，直肠镜阳性者37例，粪培养阳性者26例。此外，尚有起病急，恶寒发热，苔或黄或白，脉数等热利下重，或兼表证等特点。

方用葛根芩连汤：葛根9克，黄连4.5克，甘草4.5克，黄芩4.5克。

每日一剂，疗程最短者两天，最长者12天。40例中36例临床症状完全消失，平均退热时数27.76小时，急性症状控制平均3.44天，肉眼观血便消失平均2.83天。26例粪培养阳性者，治疗后转阴性者18例。有1例患者中途改用合霉素治疗。

（摘《江苏中医》1960，5）

抵挡汤类概述

抵挡汤类，包括了桃核承气汤、抵挡汤、抵挡丸三方。此证为太阳之邪随经入腑，血热互结于下，而成“太阳病蓄血证”。其证轻者，则见少腹急结，其人如狂等证，治用桃核承气汤；若蓄血重者，则少腹硬满，其人发狂，小便自利，或周身发黄，治疗用抵挡汤；若其人热与血瘀均轻，但少腹胀满而不硬痛，亦不见发狂等证者，则用抵挡丸治疗。

一、桃核承气汤

【药物组成】

桃仁（去皮尖）五十个 大黄四两 桂枝（去皮）二两 甘草（炙）二两 芒硝二两

【煎服法】

上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火微沸下火。先食温服五合，日三服，当微利。

【适应证】

太阳病蓄血证，而少腹急结，其人如狂，小便自利，或大便色黑者。

【原文】

第106条。

【方义】

本方即调胃承气汤加桃仁、桂枝而成。桃仁滑利而润，善能活血化瘀；大黄、芒硝则能泻热破坚，软坚化结；活血者必先理气，故用桂枝通阳行气；甘草则和诸药而安中。

【选注】

章虚谷曰：“此即调胃承气汤加桂枝、桃仁，引入血脉以破瘀结也。硝黄咸苦下降，佐桂枝、桃仁通络而破血；大黄、芒硝下瘀而泄热；甘草保其中气也。”

【按语】

《本经》谓大黄有“下瘀热”的功效。它不仅长于泻气分之实热，而又有泻血分瘀热的作用，故与桃仁配伍，而增强破瘀活血之功。用桂枝之义，在于辛温通阳行气，气行则血行，气利则血活，与桃仁有相辅相成之用。

本方对血热互结的经闭，子宫肌瘤，产后恶露不下，以及跌打损伤而形成的瘀血各证都有较好的疗效。

此证因蓄血在于下，故应以空腹服药为好。

【方歌】

桃核承气硝黄草，桃仁桂枝五药讨；

太阳蓄血腹痛急，其人如狂功效好。

【医案选录】

李某，年二十余。先患外感，诸医杂治，证屡变，医者却走。其人不远数十里踵门求诊。审视面色微黄，少腹满胀，身无寒热，坐片刻即怒目注人，手拳紧握，伸张如欲击人状，有顷即止，嗣复如初。脉沉涩，舌苔黄暗，底面露鲜红色。诊毕，主人促疏方，并询病因，答曰：病已入血，前医但知用气分药，宜其不效。《内经》言：“血在上善忘，血在下如狂。”此证即《伤寒论》“热结膀胱，其人如狂也。”当用桃核承气汤，即疏方授之。一剂知，二剂已。嗣以逍遥散加丹、栀、生地调理而安。

（摘自《遯园医案》）

二、抵当汤

【药物组成】

水蛭（熬） 虻虫（去足翅熬）各三十个 桃仁（去皮尖）二十个 大黄（酒洗）三两

【煎服法】

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下更服。

【适应证】

太阳病蓄血重证，少腹硬，小便自利，其人发狂或发黄，舌质紫或有瘀斑，脉沉涩或沉结。

【原文】

第124条、125条、237条、257条。

【方义】

水蛭、虻虫均为虫类，善能破血逐瘀，消癥化积；益以大黄、桃仁，用以荡涤血热之结。

【选注】

尤在泾：“抵当汤中，水蛭、虻虫食血去瘀之力倍于芒硝，而又无桂枝之甘辛、甘草之甘缓，视桃仁承气汤为较峻矣。盖血自下者，其血易动，故宜缓剂，以去未尽之邪；瘀热在里者，其血难动，故须峻药，以破固结之势也。”

【按语】

《本经》谓水蛭“治恶血、瘀血，破血瘕积聚”，虻虫“逐瘀血、破血积、坚痞癥瘕。”二药直入血分破其坚结，更配泄热逐瘀的大黄与润利活血的桃仁，则攻逐之力更比桃仁承气汤为峻猛。

本方治妇女血瘀经闭，瘀血癲痫，跌打损伤，瘀血凝聚等证，其效果也很理想。

【方歌】

抵当汤中用大黄，虻虫桃蛭力最强；
少腹硬满小便利，攻瘀逐热治发狂。

【医案选录】

张意田治冉口焦姓人，七月间患壮热舌赤，少腹闷满，小便自利，目赤发狂已三十余日。初服解散，继则攻下，但得微汗，而病终不解。诊之脉至沉微，重按疾急。夫表证仍在，脉反沉微者，邪陷于阴也。重按疾急者，阴不胜真阳，则脉流薄疾，并乃狂矣。此随经瘀血结于少腹也，宜服抵当汤。乃自制虻虫、水蛭，加桃仁、大黄煎服。服后下血无算，随用熟地一味捣烂煎汁，时时饮之，以救阴液。

（摘《续名医类案》）

三、抵当丸

【药物组成】

水蛭（熬）二十个 虻虫（熬，去翅足）二十个 桃仁（去皮尖）二十五个 大黄三两

【煎服法】

上四味，捣分四丸。以水一升，煮一丸，取七合服之。晬时当下血，若不下者，更服。

【适应证】

用于下焦蓄血，少腹胀满而不坚硬，病情较抵当汤为轻。

【原文】

第126条。

【方义】

同抵当汤。

【选注】

方有执：“名虽丸也，犹煮汤焉。夫汤荡也，丸缓也。变汤为丸，而犹不离乎汤，其取欲缓不缓，不荡而荡之意欤。”

【按语】

抵当丸不是蜜丸，而是水丸。药量只有抵当汤四分之一，然连渣吞服，其效力较汤为持久，故用于瘀血而病势较缓者为宜。

【方歌】

抵当丸即抵当汤，捣药成丸煮水浆；
连渣服之只一颗，缓攻瘀血正不伤。

【医案选录】

常熟鹿苑钱钦伯之妻，经停九月，腹中有块攻痛，自知非孕。医予三棱、莪术多剂未应，当延陈保厚先生诊。先生曰：三棱、莪术仅能治血结之初起者，及其已结，则力不胜矣。吾有药能治之，顾药有反响，受者幸勿骂我也。主人诺。当予抵当丸三钱，开水送下。入夜，病者在床上反复爬行，腹痛不堪，果大骂医者不已。天将旦，随大便下污物甚多，其色黄白红夹杂不一，痛乃大除。次日复诊，陈先生诘曰：昨夜骂我否？主人不能隐，具以情告，乃予加味四物汤调理而瘥。

（摘《经方实验录》第84页）

梔子豉汤类概述

梔子豉汤类共七方，其中以梔子豉汤为代表。此方治火郁心胸的“虚烦”不得眠，剧则心中懊^怏而无可奈何。若少气者，则加甘草；若呕者，则加生姜；若胸中窒或心中结痛者，则仍用原方而不必加药；若心烦腹满，卧起不安者，则减香豉，加厚朴、枳实，名梔子厚朴汤；若劳复发热，心中懊^怏者，于原方再加枳实，名枳实梔子豉汤；若兼中寒，身热胸烦而大便反溏者，则减去香豉，另加干姜，名梔子干姜汤；若因湿热发黄，兼见身热心烦脉数等证，则减去香豉，加入黄柏、甘草，名梔子柏皮汤。

梔子豉汤性味苦寒，而能泄热除烦，故病人旧有微溏而脾气虚寒的，则宜禁用为告。

一、梔子豉汤

【药物组成】

梔子（擘）十四个 香豉（绵裹）四合

【煎服法】

上二味，以水四升，先煮梔子得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服。得吐者，止后服。

【适应证】

治心烦身热、不得睡眠，剧者心中懊^怏、坐卧不宁、莫可名状；或胸脘痞塞，或胃脘疼痛、嘈杂似饥，但头汗出，舌红苔黄，脉数等证。

【原文】

第76条、77条、78条、81条，221条、228条、375条。

【方义】

梔子味苦性寒，泄热除烦，屈曲下行，降中有宣；香豉体轻气寒，宣热和胃，宣中有降。二药相合，清宣互济，发散火郁，故能开郁除烦。

【选注】

《医宗金鉴》：“未经汗吐下之烦多属热，谓之热烦；已经汗吐下之烦多属虚，谓之虚烦。不得眠者，烦不能卧也。若剧者，较烦尤甚，必反复颠倒心中懊_怱也。烦，心烦也。躁，身躁也。身之反复颠倒，则谓之躁无定时，三阴死证也；心之反复颠倒，则谓之懊_怱，三阳热证也。懊_怱者，即心中欲吐不吐，烦扰不宁之象也。因汗吐下后，邪热乘虚客于胸中所致，既无可汗之表，又无可下之里，故用梔子豉汤，顺其势以涌其热，自可愈也。”

【按语】

按治法规定，邪在表宜汗，在胸当吐，在腹应下。汗吐下三法均为邪实而设。若经汗吐下后，而见心烦不得眠，实邪虽去而余热不解，蕴于胸中所致。此证严重时，可使人反复颠倒、不得卧寐，心中懊_怱、烦闷至甚而令人无可奈何。治以梔子豉汤，清宣郁热而除郁烦。

本方又能外解太阳之邪，内清阳明之热，因胸膈外通太阳，内连阳明之故。但治热必远寒，故脾胃虚寒而大便溏者，则不宜服用。

至于本方是否为吐剂，历来注家看法不一。我们认为：吐或不吐，两种情况皆有。若火郁于上，服药后火郁得宣，正气趁机驱邪外出，吐而作解者有之；若热轻而又抑郁不甚，服后不吐者亦有之，故不得拘于吐与不吐的一个侧面。

本方先煎梔子，后内香豉，意在梔子取其味，香豉取其气，香豉气味轻薄，煎久则失掉宣散之功故也。

【方歌】

梔子豉汤治虚烦，懊_怱颠倒不得眠；
呕吐少气加姜草，胸窒结痛药不添。

【医案选录】

江应宿治都事靳相庄，患伤寒十余日，身热无汗，怫郁不得卧，非躁非烦，非寒非痛，时发一声如叹息之状。医者不知何证，迎余诊视曰：懊^怫怫郁证也。投以栀子豉汤一剂，十减二三；再以大柴胡汤下燥屎，怫郁除而安卧，调理数日而起。

（摘《名医类案》）

二、梔子甘草豉汤

【药物组成】

梔子（擘）十四个 甘草（炙）二两 香豉（绵裹）四合

【煎服法】

上三味，以水四升，先煮梔子、甘草，取二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

【适应证】

梔子豉汤证，而兼见少气之证。

【原文】

第76条。

【方义】

梔子豉汤清宣郁热，加甘草益气和中。

【选注】

成无己：“少气者，热伤气也，加甘草以益气。”

尤在泾：“少气者，呼吸少气，不足以息也。甘草之甘，可以益气。”

【按语】

本方为梔子豉汤证兼见少气而设。少气，系指呼吸少气，乃热邪内伤中气所致。不用参芪，恐助火郁，加甘草益气而不助邪。

【方歌】

见梔子豉汤方歌内。

三、梔子生姜豉汤

【药物组成】

梔子（擘）十四个 生姜五两 香豉（绵裹）四合

【煎服法】

上三味，以水四升，先煮梔子、生姜，取二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

【适应证】

梔子豉汤证，而兼见呕逆之证。

【原文】

第76条。

【方义】

梔子豉汤清宣郁热，加生姜散饮止呕。

【选注】

《医宗金鉴》：“呕者，是热迫其饮也，加生姜以散之。”

张志聪：“呕者，中气逆也，加生姜以宣通。”

【按语】

本方为梔子豉汤证兼见呕吐而设。火郁之热动饮而胃气上逆，故生姜与梔子豉汤同用，既助其宣通郁热，又有降逆止呕，和胃散饮之功。

【方歌】

见梔子豉汤歌内。

【医案选录】

赤锡乡郑某，胃脘疼痛。医治之痛不减，反增大便秘结，胸中满闷不舒，懊_忪欲呕，辗转难卧，食少神疲，历七八日。适我下乡防疫，

初返过其门，遂邀诊视。按其脉沉弦而滑，验其舌黄腻而浊，检其方多桂附香砂之属。此本系宿食为患，初只须消导之品，或可获愈。今迁延多日，酿成“夹食致虚”，补之固不可，下之宜不宜，乃针对“心中懊~~怏~~怏”、“欲呕”二症，投以生姜栀子豉汤：生栀子三钱、生姜三钱、香豉五钱，分温作两服。嘱若一服吐便止，后服再议。

服后，并无呕吐，且觉胸舒痛减，遂尽剂。翌日，病家来谢，称服药尽剂后，诸证均瘥。昨夜安然入睡，今晨大便已下，并能进食少许。

（摘《伤寒论汇要分析》第66页）

四、栀子厚朴汤

【药物组成】

栀子（擘）十四个 厚朴（炙、去皮）四两 枳实（水浸、炙令黄）四枚

【煎服法】

上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

【适应证】

治心中烦热，卧起不安，腹胀满而不痛，苔黄脉数等证。

【原文】

第79条。

【方义】

栀子苦寒，泄热除烦；厚朴苦温，行气消满；枳实苦寒，破结下气。共为清热除烦、宽中消满之剂。

【选注】

《医宗金鉴》：“论中下后满而不烦者有二：一热气入胃之实满，以承气汤下之；一寒气上逆之虚满，以厚朴生姜甘草半夏人参汤温之。其烦而不满者亦有二：一热邪入胸之虚烦，以竹叶石膏汤清之；一懊憹欲吐之心烦，以栀子豉汤吐之。今既烦且满，满甚则不能坐，烦甚则不能卧，故卧起不安也。然既无三阳之证实，又非三阴之虚证，唯热与气结，壅于胸腹之间，故宜栀子枳朴，涌其热气，则胸腹和而烦自去，满自消矣。”

柯韵伯：“心烦则难卧，腹满则难起，卧起不安，是心移热于胃，与反复颠倒之虚烦不同。栀子以治烦，枳实以泄满，此两解心腹之妙剂也。热已入胃则不当吐，便未结硬则不可下，此为小承气之先着。”

【按语】

本方证的心烦、卧起不安与栀子豉汤证相同，但又兼见腹满，说明无形邪热已由胸膈下行及腹，病变部位已渐趋里，故减去轻浮上越的香豉，而加厚朴、枳实以下气消满。此外，本证虽有腹满而无便秘，与阳明腑实的承气汤证有别。

【方歌】

栀子厚朴药有三，栀子厚朴枳实煎；
心烦腹满分上下，清烦泄满两证兼。

【医案选录】

董某，女，37岁，湖北人。自诉心发烦不能控制，必须跑到野外，心中方才稍安。兼见脘腹如同物塞，夯胀不堪。然大便并不干燥，饭食也无多大变化。切其脉弦数，视其舌尖绛而根则白腻。辨为心胃蕴郁火热，然未与糟粕等有形之物相凝结，仍属“虚烦”病类。为疏：山栀9克，枳实9克，厚朴9克。此方仅服一剂，上述诸症因之而瘳。

（刘渡舟医案）

五、栀子干姜汤

【药物组成】

栀子（擘）十四个 干姜二两

【煎服法】

上二味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

【适应证】

治身热，胸中烦热，腹满或腹痛，食少便溏。

【原文】

第80条。

【方义】

栀子苦寒，以清胸膈之邪热，则心烦可止；干姜辛热，以温脾胃之虚寒，则中阳可复。本方寒温并用，正邪兼顾，清上温中而相反相成。

【选注】

尤在泾：“大下后身热不去，证与前同。乃中无结痛，而烦又微而不甚，知正气虚，不能与邪争，虽争而亦不能胜之也。故以栀子彻胸中陷入之邪，干姜复下药损伤之气。”

柯韵伯：“攻里不远寒。用丸药大下之，寒气留中可知。心微烦而不懊_懔，则非吐剂所宜也。用栀子以解烦，倍干姜以逐内寒而散表热。寒因热用，热因寒用，二味成方，而三法备矣。”

【按语】

《医宗金鉴》说：“栀子干姜汤当是栀子豉汤，”它认为“断无烦热用干姜之理。”这种看法我们不能苟同。因为伤寒误下之后，而形成的上热下寒，或脾胃素虚之人又感外邪，则热扰于上而寒凝于中都可见到。仲景立寒热并投，上下两解之法甚是合拍。再联系论中“病人旧微

溘者，不可与服之”的禁例，可以看出，仲景立方有常有变，运用之妙，存乎一心，而不拘于寒热的一格。

【方歌】

栀子干姜治心烦，身热不去泻又添；
寒热并用分上下，清热温寒一方肩。

六、枳实栀子豉汤

【药物组成】

枳实（炙）三枚 栀子（擘）十四个 豉（绵裹）一升

【煎服法】

上三味，以清浆水七升，空煮取四升，内枳实、栀子，煮取二升，下豉，更煮五六沸，去滓，温分再服，覆令微似汗。

【加减法】

若有宿食者，内大黄如博棋子五六枚，服之愈。

【适应证】

（一）大病初愈，若调护不当，或劳作过早，因复发热口渴、心烦懊_懔、心下痞塞，或胸脘胀满，或大便硬，腹满而拒按，苔黄脉数或滑。

（二）《金匱》用治酒疸，证见：身黄发热，心中懊_懔或热痛，苔黄腻，脉滑数。

【原文】

第393条。

【方义】

本方系栀子豉汤加重豆豉的用量，再加枳实所组成。枳实宽中下行、破结消痞；栀子、豆豉泄热除烦，同时加重豆豉剂量，意在宣散郁热，且能和胃解毒。用清浆水煎药，取其性凉善走，开胃化滞，解渴除烦。若有宿食而兼见腹胀切痛，苔黄脉滑者，再加大黄以荡涤肠胃而推陈致新。

【选注】

成无己：“病有劳复、有食复。伤寒新差，血气未平，余热未尽，早作劳动病者，名曰劳复。病热少愈而强食之，热有所藏，因其谷气留

搏，两阳相合而病者，名曰食复。劳复则热气浮越，与枳实栀子豉汤以解之。食复则胃有宿积，加大黄以下之。”

尤在泾：“大病新差，血气未复，余热未尽而强力作劳，为其余热之气因劳而外浮也。枳实、栀子所以下热，豆豉所以散热，盖亦表里之剂，而气味轻薄，适宜于病后复发之体耳。”

【按语】

大病初愈，正气尚未全复，若调摄失宜，或妄动作劳，或饮食不节，都能导致其病复发。如果证见胸满心烦、懊憹不舒、心下痞塞、发热而病势偏于表者，服本方温覆取微汗尤为相宜。如果兼有宿食，病势偏于里者，再加大黄如博棋子大，微下则愈。总之，病后用药，祛邪虽为急务，但正气亦不可不顾。临床必须根据具体情况以决定治疗措施，才能做到理法方药丝丝入扣，从而达到邪去正复之目的。

《金匮要略·黄疸病脉证治》有栀子大黄汤，即本方加大黄，再加重枳实的用量而成。能治疗“酒疸”发黄，有和胃除烦、利湿通便之效。二方互参，以见其义。

【方歌】

枳实栀豉劳复宝，食复再加大黄好；

酒疸心热且懊憹，栀子大黄力能讨。

七、梔子柏皮汤

【药物组成】

肥梔子（擘）十五个 甘草（炙）一两 黄柏二两

【煎服法】

上三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。

【适应证】

身热发黄，心烦，渴不多饮，汗出不彻，小便短赤，苔黄而脉数。

【原文】

第261条。

【方义】

梔子苦寒，清三焦而利小便；黄柏苦寒，清热燥湿又能坚阴；甘草和胃健脾，又能制梔柏之寒。此方清解里热，兼以燥湿，对热重于湿，正气稍衰，以及阴分伏热之黄尤为合宜。

【选注】

《医宗金鉴》：“伤寒身黄发热者，设有无汗之表，宜用麻黄连轺赤小豆汗之可也。若有成实之里，宜用茵陈蒿汤下之亦可也。今外无可汗之表证，内无可下之里证，故唯宜以梔子柏皮汤清之也。”

尤在泾：“此热瘀而未实之证。热瘀，故身黄；热未实，故发热而腹不满。梔子彻热于上，柏皮清热于下，而中未及实，故须甘草以和之耳。”

【按语】

本方在临床应用上，虽不及茵陈蒿汤广泛，但对于某些湿热黄疸，久治不愈，脾胃受损，正气稍衰，而阴分伏热者，有时可以收到意想不到的效果。至于方中甘草的使用，有些注家持有异议，其实正是仲景制方精妙之处。甘草甘平和中，既能防梔柏苦寒伤胃，又有扶脾解毒之功。

【方歌】

梔子柏皮濕熱黃，發熱尿赤量不長；
梔子黃柏兼甘草，清熱去濕好思量。

【醫案選錄】

唐某，男，16歲。患急性黃疸型肝炎，因循失治，皮膚黃色變黑，足熱心煩，大便溏薄，脈弦數而舌紅。前醫用茵陳蒿湯已十餘劑而效不顯。改用大甘露飲和梔子柏皮湯，約一月而病轉安。

（劉渡舟醫案）

陷胸汤类概述

陷胸汤类，指治疗热实结胸的大陷胸丸、大陷胸汤和小陷胸汤。这三个方子，在治疗上有轻重缓急之分，在病理上亦有或上或下之别，然解决热与痰水凝结则一。其中的大陷胸丸治水热偏结于上的项背强急，如“柔痉”状；大陷胸汤治水热互结，而见心下痛、按之石硬，或下连少腹，疼痛拒按；小陷胸汤治痰热结于心下，上不及项背，下不及少腹，而正在心下，按之则痛，脉见浮滑。

除热实结胸外，同时又论述了十枣汤证。十枣汤治胁下停留水饮，名叫“悬饮”。其证亦有心下痞硬，而不同于结胸者在于“引胁下痛”为辨。若其人不属热实结胸，而属于寒实结胸者，则改用白散治疗。其证亦见胸中或心下硬痛，但不见发热、口渴、心烦等热象为异。

瓜蒂散虽不治结胸，然能涌吐胸脘痰水之凝结，以治胸中痞硬，气上冲喉咽不得息，手足厥冷，心下烦满等证。它与结胸证有内在的千丝万缕联系，故附于白散之后。

一、大陷胸丸

【药物组成】

大黄半斤 葶苈子（熬）半升 芒硝半升 杏仁（去皮尖、熬黑）半升

【煎服法】

上四味，捣筛二味，内杏仁、芒硝，合研如脂和散。取如弹丸一枚，别捣甘遂末一钱匕、白蜜二合、水二升，煮取一升，温顿服之。一宿乃下。如不下，更服，取下为效。禁如药法。

【适应证】

治结胸证，而胸部硬痛，汗出，项强拘急，如“柔痉”状者。

【原文】

第131条。

【方义】

甘遂、大黄、芒硝逐水热之结，葶苈子泻胸肺之热，杏仁利肺以助下行，用白蜂蜜为丸，每服仅一丸，则药峻而治缓，能搜尽在上之邪。

【选注】

尤在泾：“痉病之状，颈项强直。结胸之甚者，热与饮结，胸膈紧贯，上连于项，但能仰而不能俯，亦如痉病之状也。曰柔而不曰刚者，以阳气内陷者，必不能外闭，而汗常自出耳。是宜下其胸中结聚之实，则强者得和而愈。然胸中盛满之邪，固非小陷胸所能去；而水热互结之实，亦非承气汤所可治。故与葶苈之苦，甘遂之辛，以破结饮而泄气闭；杏仁之辛，白蜜之甘，以缓下趋之势，而去上膈之邪；其芒硝、大黄，则资其软坚荡实之能。”至于用丸之理，尤氏又云：“汤者，荡也，荡涤邪秽，欲使其净尽也。丸者，缓也，和理脏腑，不欲其速下也。大陷胸丸以荡涤之体，为和缓之用。盖以其邪结在胸，而至如柔痉状，则非峻药不能逐之，而又不可以急剂一下而尽，故变汤为丸，煮而并渣服之，乃峻药缓用之法。峻则能胜破坚荡实之任，缓则能尽际上迄下之邪也。”

【按语】

大陷胸丸为缓攻在上之邪而设。故用白蜜之甘缓，使药留恋于上，以荡涤胸膈之邪。用杏仁、葶苈之意虽是利肺，实有陷下胸邪的作用。以药测证，可能还有呼吸不利、气喘与小便不利等证。

【方歌】

大陷胸丸法最超，半升葶苈杏硝调；
项强如痉君须记，大黄甘遂下之消。

【医案选录】

天津罗某，素有茶癖，每日把壶长饮，习以为常。身体硕胖，面目光亮，每以身健而自豪。冬季感受风寒后，自服青宁丸与救苦丹，病不效而胸中硬疼，呼吸不利，项背拘急，俯仰为难。经人介绍，乃请余诊。其脉弦而有力，舌苔白厚而腻。辨为伏饮踞于胸膈，而风寒之邪又化热入里，热与水结于上，乃大陷胸丸证。

为疏：大黄6克，芒硝6克，葶苈子、杏仁各9克。水二碗，蜜半碗，煎成多半碗，后下甘遂末1克。

服一剂，大便泻下两次，而胸中顿爽。又服一剂，泻下四次。从此病告愈，而饮茶之嗜亦淡。

（刘渡舟医案）

二、大陷胸汤

【药物组成】

大黄（去皮）六两 芒硝一升 甘遂一钱匕

【煎服法】

上三味，以水六升，先煮大黄取二升，去滓，内芒硝，煮一两沸，内甘遂末，温服一升。得快利，止后服。

【适应证】

心下硬痛，按之石硬，或牵连胸胁，头微汗出，或从心下至少腹硬满而痛不可近，舌苔黄厚，脉沉紧有力。

【原文】

第134条、135条、136条、137条、149条。

【方义】

大黄苦寒，泄热破结；芒硝咸寒，软坚开结；甘遂苦寒，峻逐水邪。共成泄热逐水破结之功。

【选注】

尤在泾：“按大陷胸与大承气，其用有心下与胃中之分。以愚观之，仲景所云心下者，正胃之谓；所云胃中者，正大小肠之谓也。胃为都会，水谷并居，清浊未分，邪气入之，夹痰杂食，相结不解，则成结胸。大小肠者，精华已去，糟粕独居，邪气入之，但与秽物结成燥粪而已。大承气专主肠中燥粪，大陷胸并主心下水食。燥粪在肠，必藉推逐之力，故须枳朴；水食在胃，必兼破饮之长，故用甘遂。且大承气先煮枳朴，而后内大黄，大陷胸先煮大黄，而后内诸药。夫治上者制宜缓，治下者制宜急，而大黄生则行速，熟则行迟，盖即一物，而其用又有不同如此。”

【按语】

尤氏对大承气汤与大陷胸汤的鉴别分析，论述颇为精当。夫药物配

伍之不同，煎煮先后之有别，其治疗作用亦因之而异。故本方比大承气汤更为峻猛，必须审证无误，方可使用。服后中病即止，以免伤正。若虚人、老人、孕妇则应禁用。

【方歌】

大陷胸汤遂硝黄，心下硬痛脉紧强；
热气内陷水热结，小有潮热要参详。

【医案选录】

沈家湾陈姓孩，年十四，独生子也，其母爱逾掌珠。一日忽得病，邀余出诊。脉洪大，大热，口干，自汗，右足不得伸屈，病属阳明。然口虽渴，终日不欲饮水，胸部如塞，按之似痛，不胀不硬，又类悬饮内痛。大便五日未通，上湿下燥，于此可见，且太阳之湿内入胸膈，与阳明内热同病，不攻其湿痰，燥热焉除？于是，遂书大陷胸汤与之。

制甘遂一钱五分，大黄三钱，芒硝二钱。

服后大便畅通，燥屎与痰涎先后俱下，今已安适矣。其余诸恙，均各霍然。

（摘《经方实验录》第69页）

三、十枣汤

【药物组成】

芫花（熬） 甘遂 大戟

【煎服法】

上三味，等分，各别捣为散。以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药末。强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平旦服。若下少病不除者，明日更服加半钱。得快下利后，糜粥自养。

【适应证】

心下痞硬满，引胁下疼痛，干呕短气，头痛，微汗出，不恶寒，发作有时，脉弦紧。

【原文】

第152条。

【方义】

芫花、大戟、甘遂三药为泻水逐饮的峻剂，长于攻逐胸腹积液，能一鼓而下。然逐水又恐伤正，故以大枣固护脾胃而滋津液，务使邪去正不伤，而为有制之师。

【选注】

尤在泾：“《金匱》云：饮后水流在胁下，咳吐引痛，谓之悬饮。又云：病悬饮者，十枣汤主之。此心下痞硬满引胁下痛，所以知其为悬饮也。悬饮非攻不去，芫花、甘遂、大戟并逐饮之峻药，而欲攻其饮，必顾其正，大枣甘温以益中气，使不受药毒也。”

【按语】

本证有头痛汗出，而无发热恶寒脉浮等证，说明表邪已解，当攻其里。若见发热恶寒、头痛汗出、脉浮等证，则表证未解，当先解表，而后攻里。

本方峻猛，又令空腹服，则药力攻邪不受食阻。若病不除，再适当

加重药量。体弱及孕妇忌服，恐正虚而不支。

据报道，本方用于西医的胸膜炎、胸腔积液、肝硬化腹水，若体实而正气不衰者，此方确有疗效。

【方歌】

十枣汤治胁下水，心下痞硬胁痛锐；
甘遂芫戟研细末，枣汤煮浓服钱匕。

【医案选录】

唐杲，字德明，善医。太仓武指挥妻，起立如常，卧则气绝欲死。杲言：是为悬饮。饮在喉间，坐之则坠，故无害；卧则壅塞阻窍，不得出入而欲死。投以十枣汤而平。

（摘《嘉定县志》）

四、小陷胸汤

【药物组成】

黄连一两 半夏（洗）半升 栝蒌实（大者）一枚

【煎服法】

上三味，以水六升，先煮栝蒌取三升，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。

【适应证】

治痰热郁结，心下痞硬，按之则痛，痰涎多，苔黄腻，脉浮滑。

【原文】

第138条。

【方义】

栝蒌实甘寒滑润，清热涤痰，宽胸利肠，并能开血脉之结；黄连苦寒清热；半夏辛温化痰。共成清利痰热，以开心下之结。

【选注】

柯韵伯：“结胸有轻重，立方分大小。从心下至小腹按之石硬而痛不可近者，为大结胸。正在心下，未及胸腹，按之则痛，未见石硬者，为小结胸。大结胸是水结在胸腹，故脉沉紧；小结胸是痰结于心下，故脉浮滑。水结宜下，故用甘遂、葶、杏、硝、黄等下之；痰结可消，故用黄连、栝蒌、半夏以消之。水气能结而为痰，其人之阳气重可知矣。”

《医宗金鉴》：“黄连涤热，半夏导饮，栝蒌润而下行。合之以涤胸膈痰热，开胸膈气结。攻虽不峻，亦能突围而入，故名小陷胸汤。分温三服，乃缓以治上之法也。”

【按语】

本方主治痰热之邪结于胃脘，不蔓不枝，正在心下的小结胸证。与大结胸证相比，虽皆三药组成，却有大小缓急之分。此用黄连清热，彼

用大黄泻热；此用半夏辛开化痰，彼用甘遂峻逐水饮；此用栝蒌实涤痰利便，彼用芒硝软坚泻下。可见，证有轻重之殊，方有大小之别。

本方栝蒌实要先煮。仲景云“大者一枚”，即合现在剂量约80克。栝蒌实在方中起主要作用，有涤痰结、利大肠、通下胸中郁热以及活血止痛之功。

服本方后，常泻下黄色黏涎而愈。常用于治疗急性胃炎、渗出性胸膜炎、支气管肺炎等。若兼见胸胁苦满者，本方可与小柴胡汤合方，名为柴陷汤，用之得当，效如桴鼓。

【方歌】

小陷胸汤大瓜蒌，半夏黄连三药投；
痰热胶结心下痛，利痰清热服之瘳。

【医案选录】

孙某，女，58岁。胃脘作痛，按之益甚。痛处鼓起一包，如鸡卵大小，按之不硬而软，患者忧心忡忡，乃急到医院检查，而放射科之X光钡餐造影登记，须一月后始能轮到，不得已，乃延中医治疗。余切其脉弦滑有力，舌苔白中带黄，问其二便，则称正常，而饮食亦无倒饱吞酸等象。证属痰热内凝，胃中络脉瘀滞，正陈修园所谓“脉络凝邪心下成”之证是也。为疏：糖瓜蒌30克，黄连9克，半夏10克。

此方共服三剂，大便解下黄色黏液。从此，疼止而心下之包亦消。

（刘渡舟医案）

五、白散

【药物组成】

桔梗三分 巴豆（去皮心、熬黑、研如脂）一分 贝母三分

【煎服法】

上三味为散，内巴豆，更于臼中杵之，以白饮和服。强人半钱匕，羸者减之。病在膈上必吐，在膈下必利。不利，进热粥一杯。利过不止，进冷粥一杯

【适应证】

证见胸中或心下硬满疼痛拒按，呼吸不利，大便不通，而无烦渴等热证，舌苔白滑，脉沉弦或沉迟有力。

【原文】

第141条。

【方义】

巴豆辛热力猛，能泻寒痰冷饮积聚，辅以贝母开结解郁；桔梗开肺气之闭，又能载药上行，一举而下胸中寒实。用白饮服药，恐峻药伤正，所以护胃气也。

【选注】

《医宗金鉴》：“是方也，治寒实水结胸证，极峻之药也。君以巴豆，极辛极烈，攻寒逐水，斩关夺门，所到之处，无不破也；佐以贝母，开胸之结；使以桔梗，为之舟楫，载巴豆搜逐胸邪，悉尽无余。膈上者必吐，膈下者必利。然唯知任毒以攻邪，不量强羸，鲜能善其后也，故羸者减之。”

【按语】

寒实结胸，以寒痰冷饮结于胸膈，胸部硬满疼痛，但无口渴、发热、苔黄等热象为辨。本方服后，或吐或下，都是逐邪外出的反应。若服药不利，则服热粥以助泻下。若下利不止，则服冷粥以止下利，因巴

豆得热则行，遇冷则止故也。

【方歌】

白散三物巴桔贝，寒实结胸此方贵；
或吐或利分上下，中病即止莫伤胃。

【医案选录】

郑某，七十余岁。素嗜酒，并有慢性气管炎，咳嗽痰多，其中痰湿恒盛。时在初春某日，大吃酒肉饭后，即入床眠睡，翌日不起，至晚出现昏糊，询知瞠目不知答。因其不发热、不气急，第三天始邀余诊。两手脉滑大有力，满口痰涎粘连，舌苔厚腻浊垢，呼之不应，问之不答，两目呆瞪直视，瞳孔反应正常，按压其胸腹部，则患者蹙眉，大便不行，小便自遗，因作寒实结胸论治。用桔梗白散五分，嘱服三回，以温开水调和，缓缓灌服。二次药后，呕吐黏腻胶痰，旋即发出长叹息呻吟声。三次药后，腹中鸣响，得泻下两次，患者始觉胸痛、发热、口渴欲索饮。继以小陷胸汤两剂而愈。

（摘《江苏中医》1961，8）

六、瓜蒂散

【药物组成】

瓜蒂（熬黄）一分 赤小豆一分

【煎服法】

上二味，各别捣筛，为散已，合治之，取一钱匕。以香豉一合，用热汤七合煮作稀糜，去滓，取汁和散，温顿服之。不吐者，少少加。得快吐乃止。（诸亡血虚家，不可与瓜蒂散。）

【适应证】

治病如桂枝证，头不痛、项不强、寸脉微浮、胸中痞硬、气上冲咽喉不得息，或手足厥冷，脉乍紧，心下满而烦，饥不能食等证。

【原文】

第166条、355条。

【方义】

瓜蒂味极苦，赤小豆味微酸，二药配伍，而有酸苦涌泄的作用；豆豉轻宣辛散，载药上浮，助瓜蒂以催吐，使上焦寒实从上越出。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡胸中寒热与气与饮郁结为病，谅非汗下之法所能治，必得酸苦涌泄之品因而越之，上焦得通，阳气得复，痞硬可消，胸中可知也。瓜蒂极苦，赤豆味酸，相须相益，能疏胸中实邪，为吐剂中第一品也。而佐香豉汁合服者，借谷气以保胃气也。此方奏功之捷，胜于汗下，所谓汗吐下三大法也。今人不知仲景、子和之精义，置之不用，可胜惜哉！然诸亡血虚家，胸中气液已亏，不可轻与，特为申禁。”

【按语】

胸中痰邪闭郁，而使胸中痞硬，气上冲咽喉不得息。营卫之气从胸中发于体表，今痰实壅郁于胸，营卫之气流流行不畅，所以出现恶寒发

热，类似中风之证。然脉反寸部微浮，关尺皆沉而不起，反映胸部之邪而有上出之机，故可因势利导，用瓜蒂散吐之。若胸中郁闭，阻遏阳气不能达于四肢，又可出现心下满而烦、手足厥冷等证。

服瓜蒂散后，吐出菜汁样绿水或黄水，或稠涎黏痰则病愈。但用此法时，应注意以下几点：

1.由于涌吐时气机向上向外，往往头身出汗，应嘱患者避风寒以防感冒。

2.吐时还可引起头晕、面赤、心慌等象，应让患者闭目静坐，少顷即解。

3.吐时用宽布带扎紧腹部以助吐力。

4.若药后吐不止者，可用葱白煎汤以解之。

5.若药后不吐者，可口含糖即吐，或以指探吐。

汗吐下三法为祛邪救急之法。然时至今日，吐法已不为医家所采用，有名存实亡之感，亟应引起注意。

【方歌】

瓜蒂散是涌吐方，胸中痞硬痰邪猖；

气冲咽喉不得息，蒂豆研散调豉汤。

【医案选录】

信州老兵女三岁，因食盐虾过多，得齁喘之疾，乳食不进。贫无可召医治，一道人过门，见病女喘不止，便叫取甜瓜蒂七枚，研为粗末，用冷水半茶盏许，调澄取清汁呷一小呷。如其言，才饮竟，即吐痰涎若粘胶状，胸次既宽，齁喘亦定。少日再作，又服之，随手愈。凡三进药，病根如扫。

（摘《名医类案》）

泻心汤类概述

泻心汤类共有五方，即半夏泻心汤、大黄黄连泻心汤、附子泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤。为了比类发明，并把旋覆代赭汤列于其后。

泻心汤是治疗心下痞气的主方。它是因于脾胃之气不和，升降之机乖戾，使气痞于心下所致。因此，它兼有胃气不降的呕吐、噎气和脾气不升的大便下利等证。至于热邪结于心下的热痞，以及上热下寒导致的卫阳不能固表的恶寒汗出之痞，虽不能完全归咎于脾胃的气机升降失调，然气机痞于心下，而使胃脘之气不和则一。所以，五个泻心汤中，调和脾胃阴阳而治心下痞气则只有半夏泻心、生姜泻心、甘草泻心汤三方。余如大黄黄连泻心汤和附子泻心汤，乃是针对寒热具体情况而制定的，它们虽有心下痞证，而其病机似应另当别论。

旋覆代赭汤证，也兼见心下痞，可以作为泻心汤的类证，但病机属于胃虚肝逆，而又痰气相因，故虽有噎气不除之特点，然无呕吐下利之变，而与脾胃升降失序者又有不同，故亦不得混为一谈。

一、半夏泻心汤

【药物组成】

半夏（洗）半升 黄芩 干姜 人参 甘草（炙）各三两 黄连一两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煮取三升，温服一升，日三服。

【适应证】

本证的特点：中见心下痞满不舒，上见呕吐或带酸苦，下见大便泻利，舌苔白腻，脉多见滑，而是其候。

【原文】

第149条。

【方义】

本方系小柴胡汤去柴胡、生姜，加黄连、干姜而成。半夏泻心汤属于和解剂之一，其病由于中州气机升降不利，中焦痞塞，胃气不降而生热，故以芩连之苦寒以降之；脾气不升而生寒，故用干姜之辛热以温之；痰饮扰胃，上逆作吐，故用半夏化饮降逆止吐；脾胃气弱，不能斡旋上下，故以参草枣以补之。本方清上温下，苦降辛升，蠲痰消痞，为治疗心下痞的主方。

【选注】

尤在泾：“痞者，满则不实之谓。夫客邪内陷，即不可从汗泄，而满而不实，又不可从下夺，故惟半夏、干姜之辛，能善开其结；黄连、黄芩之苦，能泄其满。而其所以泄与散者，虽药之能，而实胃气之使也。用参草枣者，以下后中虚，故以之益气，而助其药之能也。”

【按语】

本方由小柴胡汤加减变化而成。方中寒温并用，辛开苦降甘调于一

炉共治，为和解脾胃寒热而设之方。本方为治疗脾胃疾病开辟了一条途径，在临床上，对单纯的脾胃热证寒证较易医治，而对于脾胃运化失常所产生的寒热夹杂、升降乖戾之证，若不明和解脾胃阴阳之法，则往往令人束手无策。目前，本方广泛应用于急慢性胃炎、消化道溃疡、慢性肠炎、消化不良等病证。如运用得当，常可取得满意的疗效。

【方歌】

半夏泻心芩连姜，人参草枣合成方；

心下痞满兼呕吐，去滓重煎调胃肠。

【医案选录】

张某，男，司机，素嗜酒。1969年发现呕吐，心下痞闷，大便每日两三次而不成形。经多方治疗效不显。其脉弦滑，舌苔白，辨为酒湿伤胃，郁而生痰，痰浊为邪，胃气复虚，影响升降之机，则上见呕吐，中见痞满，下见腹泻。治以和胃降逆，去痰消痞为主。

拟方：半夏12克，干姜6克，黄芩6克，黄连6克，党参9克，炙甘草9克，大枣7枚。

服一剂，大便泻下白色胶涎甚多，呕吐十去其七。又服一剂，则痞利皆减。凡四剂痊愈。

（刘渡舟医案）

二、大黄黄连泻心汤

【药物组成】

大黄二两 黄连一两

【煎服法】

上二味，以麻沸汤二升渍之，须臾，绞去滓，分温再服。

【适应证】

（一）心下痞满，按之不痛，心烦溲赤，大便不爽，舌红苔黄，脉浮或数。

（二）治心下痞，兼吐血、衄血等火热迫血妄行证。

【原文】

第154条、164条。

【方义】

大黄苦寒，泄热而破结；配黄连之苦寒，以清心胃火邪。俾火邪去而气和，则痞满可除。

【选注】

成无己：“《内经》曰：火热受邪，心病生焉。苦入心，寒除热，大黄、黄连之苦寒，以导泻心下之虚热。但以麻沸汤渍服者，取其气薄而泻虚热。”

钱潢曰：“心下者，心之下，中脘之上，胃之上脘也。胃居心之下，故曰心下也。其脉关上浮者，浮为阳邪，浮主在上，关为中焦，寸为上焦，因邪在中焦，故关上浮也。按之濡，乃无形之邪热也。热虽无形，然非苦寒以泄之不能去也，故以此汤主之。”

【按语】

本方乃治疗热痞的正治之法。成注所云“虚热”者，意指无形邪热结于心下，其中并无实物可言。故服用本方不必煎煮，而以沸水浸泡片

刻，然后绞汁去滓即可服用。这种制药方法，在于取其寒气之轻扬以泄热，避其苦味之重浊以攻下。

本方仅大黄、黄连二味，然附子泻心汤则用大黄、黄连、黄芩三味，恐前方中亦有黄芩，而后但加附子。又《千金翼方》注云：“此方本有黄芩”，再考《金匱·惊悸吐衄篇》的泻心汤亦芩连并用，可见本方有黄芩为理想，以增强清热泄痞之功。

本方临床上应用较广，不仅是治疗热痞的主方，也能治疗因于火邪的诸般血证。《圣惠方》还用本方治疗：丈夫、妇人三焦积热之眼目赤肿、头项肿痛，口舌生疮、心膈烦躁、小便赤涩，大便秘结，粪门肿痛等证，反映了其清热的作用为优。

【方歌】

大黄黄连泻心汤，黄芩黄连和大黄；
清热泄痞沸汤渍，擅治烦躁吐衄殃。

【医案选录】

甘肃高寨孙某，60岁。鼻衄如注，心烦不眠，心下痞满，小便发黄，大便不爽，舌质红而苔薄黄，六脉皆数。辨为心胃之火上炎，扰动气血。气不和则心下痞满，血被灼则鼻衄不止。治当泻心清热，则气血自安。

处方：生大黄9克，黄连6克，黄芩6克。

用滚汤浸药片刻，饮一碗，而衄痞皆愈。

（刘渡舟医案）

三、附子泻心汤

【药物组成】

大黄二两 黄连一两 黄芩一两 附子（炮去皮、破，别煮取汁）一枚

【煎服法】

上四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾，绞去滓，内附子汁，分温再服。

【适应证】

上述之热痞，而又兼见恶寒汗出之证。

【原文】

第155条。

【方义】

大黄、黄连、黄芩苦寒泄热，沸水浸渍以泄气分之痞；附子辛热，别煮取汁，用以扶阳固表止汗。共为寒热并用，正邪兼顾之剂。

【选注】

尤在泾：“按此证邪热有余而正阳不足，设治邪而遗正，则恶寒益甚；或补阳而遗热，则痞满愈增。此方寒热补泻并投互治，诚不得已之苦心，然使无法以制之，鲜不混而无功矣。方以麻沸汤渍寒药，别煮附子取汁，合和与服，则寒热异其气，生熟异其性，药虽同行，而功则各奏，乃先圣之妙用也。”

【按语】

本方中三黄生用，沸水浸渍，是取其轻清之气，以泄上焦之热。尤妙在附子熟用另煎，是取其醇厚之味，以温下焦之寒。如是，阳得附子而复，则恶寒汗出愈；热得三黄而除，则心下痞满自消。

本汤证应与热痞兼表未解者相鉴别。如果其人恶寒汗出，而又有发热脉浮、头项强痛等证，则宜遵先表后里的治疗原则，宜用桂枝汤先解其表，表解后，方可用大黄黄连泻心汤泄其痞。

【方歌】

附子泻心芩连黄，恶寒汗出痞为殃；
专煎轻渍须记住，泻热之中又扶阳。

【医案选录】

宁乡学生某，得外感数月，屡治不愈。延诊时，自云腹满，上身热而汗出，腰以下恶风。时夏历六月，以被围绕。取视前方，皆时俗清利，搔不着痒之品。舌苔淡黄，脉弦。与附子泻心汤。阅二日复诊，云药完二剂，疾如失矣。为疏善后方而归。

（摘《遯园医案》）

四、生姜泻心汤

【药物组成】

生姜（切）四两 甘草（炙）三两 人参三两 干姜一两 黄芩三两 半夏（洗）半升 黄连一两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。（附子泻心汤，本云加附子，半夏泻心汤、甘草泻心汤，同体别名耳。生姜泻心汤，本云理中人参黄芩汤去桂枝、术，加黄连，并泻肝法）。

【适应证】

胃中不和，心下痞硬，干噎食臭，肠鸣下利，或胁下作痛，小便不利，脉沉弦，舌苔水滑。

【原文】

第157条。

【方义】

本方即半夏泻心汤加生姜而成。证属脾胃虚弱，中气不运，故饮食难于消化，致使水饮内停而成痞。药用生姜健胃以散水饮，佐以半夏涤痰消痞气；干姜温中以去寒邪；人参、甘草、大枣甘温扶虚，补中益气；黄芩、黄连苦寒而降，以治胃气上逆。

【选注】

《医宗金鉴》：“名生姜泻心汤者，其义重在散水气之痞也。生姜、半夏散胁下之水气；人参、大枣补中州之土虚；干姜、甘草以温里寒；黄芩、黄连以泄痞热。此方备乎虚水寒热之治，对胃中不和下利之痞，焉有不愈者乎？”

尤在泾：“汗解之后，胃中不和，既不能运行真气，并不能消化饮食，于是心中痞硬，干噎食臭。《金匱》所谓中焦气未和，不能消谷，故令人噎是也。噎，噎食气也。胁下有水气，腹中雷鸣下利者，土得不

及而水邪为殃也。故以泻心消痞，加生姜以和胃。”

【按语】

本方治胃不和而有水气之痞。此证水气虽已波及胁下，但病根犹在于胃。因寒热互结较重，故心下痞满且硬。胃虚食滞，故见干噎食臭等证。本方与半夏泻心汤相比，而以水气之患为突出。水气不化而横流，故胁下作痛；若水走肠间，则腹中雷鸣下利。所以，本方重用生姜之辛散，以和胃散水，他药则与半夏泻心汤同。本证如见小便不利，亦可酌加茯苓为要。

【方歌】

生姜泻心是良方，胃中不和痞为殃；

噎气下利芩连草，参枣半夏与二姜。

【医案选录】

潘某，女，49岁，湖北潜江人。主诉心下痞塞，当胃脘处高起如鸡卵大小，噎气频作，呕吐酸苦，大便溏稀，肠鸣漉漉，饮食少思。查其人体胖，面浮肿，色青黄而不泽；视其心下隆起一包，按之则没，抬手则起。六脉滑而无力，舌苔水滑。辨为脾胃之气不和，以致升降失序，中挟水饮，故而成痞。气聚不达则心下隆起，然按之无物，但气痞耳，故按之则消。为疏生姜泻心汤加茯苓，连服八剂，痞消包平而愈。

（刘渡舟医案）

五、甘草泻心汤

【药物组成】

甘草（炙）四两 黄芩三两 干姜三两 半夏（洗）半升 大枣（擘）十二枚 黄连一两

【煎服法】

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【适应证】

心下痞硬而满，腹中雷鸣，下利频作，水谷不化，干呕心烦不得安。

【原文】

第158条。

【方义】

本方即半夏泻心汤减人参，加重甘草之剂量而成。方以甘草命名，义在缓客气之逆，益中州之虚；佐以大枣之甘，则扶虚之力为大；半夏辛降，和胃消痞；芩连清其客热，干姜温其里寒。务使中气健运，寒热消散，胃气不痞，客气不逆则愈。

【选注】

尤在泾：“伤寒中风者，成氏所谓伤寒或中风者是也。邪盛于表而反下之，为下利谷不化，腹中雷鸣，为心下痞硬而满，为干呕心烦不得安，是表邪内陷心间，而复上攻下注，非中气空虚，何致邪气淫溢至此哉？医以为结热未去，而复下之，是已虚而益虚也。虚则气不得化，邪愈上逆，而痞硬有加矣。故与泻心消痞，加甘草以益中气。”

《医宗金鉴》：“方以甘草命名者，取和缓之意也。用甘草、大枣之甘，补中之虚，缓中之急；半夏之辛，降逆止呕；芩连之寒，泻阳陷之痞热；干姜之热，散阴凝之痞寒，缓中降逆，泻痞除烦，寒热并用也。”

【按语】

本方由于反复误下，脾胃气虚较重，成痞利俱甚的心下痞证。但本方却无人参，与半夏泻心汤相比较，只是增加了一两甘草，却少了三两人参。按林亿所云，此方无人参，乃脱落之过，故本方当有人参为是。

半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤均为治疗心下痞的方剂，皆以脾胃升降失常，寒热错杂而出现的心下痞满与呕利等证为主。三方药物相仿，治疗略同，但同中有异。其中辛开苦降甘调而各有偏重。如半夏泻心汤证以心下痞兼呕为主；生姜泻心汤证则以心下痞硬，干噎食臭，胁下有水气，腹中雷鸣与下利为主；甘草泻心汤证则以痞利俱甚，谷气不化，客气上逆，干呕心烦不得安为主。临床应细心体察每方的特点，而选择运用。

【方歌】

甘草泻心用芩连，干姜半夏参枣全；
心下痞硬下利甚，更治狐惑心热烦。

【医案选录】

郑某，女，32岁。其证上则口腔经常糜烂作痛，而不易愈合；下则前阴黏膜溃破，既痛且痒；中则心下痞满，饮食乏味。切其脉弦而无力，舌有薄白之苔，颊部黏膜溃烂成疮。问其小便尚称正常，唯大便每日两次而成形，辨为脾虚不运，升降失常，气痞于中，而又挟有毒之害。治宜健脾调中，兼解虫毒。

处方：炙甘草12克，黄芩9克，人参9克，干姜9克，黄连6克，半夏10克，大枣7枚。此方共服十数剂，而诸症逐渐得瘳。

（刘渡舟医案）

六、旋覆代赭汤

【药物组成】

旋覆花三两 人参三两 生姜（切）五两 代赭一两 甘草（炙）三两 半夏（洗）半升 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【适应证】

胃虚而肝气挟痰饮以上逆，故心下痞硬，噎气不除，甚至呕吐痰涎，头目眩晕，舌质淡，苔白滑，脉来弦。

【原文】

第161条。

【方义】

旋覆花疏肝利肺，除水下气；代赭石质重下沉，镇肝降逆；更以半夏、生姜温化痰饮，消痞散结；人参、炙甘草、大枣补中益气，以照顾中土之虚。

【选注】

罗天益：“汗吐下解后，邪虽去而胃气已亏矣。胃气既亏，三焦因之失职，清无所归而不升，浊无所纳而不降，是以邪气留滞，伏饮为逆，故心下痞硬，噎气不除也。方中以人参、甘草养正补虚；生姜、大枣和脾养胃，所以安定中州者至矣；更以代赭石之重，敛浮镇逆；旋覆花之辛，用以宣气涤饮，佐人参以归气于下，佐半夏以蠲饮于上。浊降则痞硬可消，清升则噎气可除矣。观仲景治少阴水气上凌，用真武汤镇之；治下焦滑脱不守，用赤石脂禹余粮汤固之。此胃虚气失升降，复用此法理之，则胸中转否为泰。其为归元固下之法，各极其妙如此。”

【按语】

本方原文中有“噫气不除”一证，考其意义有三：一则噫气不除，持续不断，频频发作；二则心下痞硬，不因噫气而减；三则或已服生姜泻心汤，而噫气与心下痞硬不除。因本证为中虚有饮，虽与生姜泻心汤证同，但土虚木乘，肝气上逆，故噫气不除乃是本证的特点。且噫气不除，重于干噫食臭，而无腹中雷鸣下利等证，故既要补虚和胃化饮，更须要降逆平肝，方能获效。方用旋覆花三两、代赭石一两、生姜五两，三药之剂量比例有一定的治疗意义，切不得任意改动。

本方用于治疗杂病的呃逆、呕吐，反胃等证，凡符合本病情的也同样有效。有人在临床用治美尼尔氏综合征的呕吐，据说效果很好。

【方歌】

旋覆代赭痞在中，噫气不除饮气冲；

参草姜枣半夏予，赭轻姜重方奏功。

【医案选录】

魏生诊治一妇女，噫气频作而心下痞闷，脉来弦溃，按之无力。辨为脾虚肝逆，痰气上攻之证。为疏：旋覆花9克，党参9克，半夏9克，生姜3片，代赭石30克，炙甘草9克，大枣3枚。令服三剂，然效果不显，乃请余会诊。诊毕，视方辨证无误，乃将生姜剂量增至15克，代赭石则减至6克，嘱再服三剂，而病竟大减。

魏生不解其故。余曰：仲景此方的剂量原来如此。因饮与气搏于心下，非重用生姜不能开散。代赭能镇肝逆，使气下降，但用至30克则直驱下焦，反掣生姜、半夏之肘，而于中焦之痞则无功，故减其剂量则获效。可见经方之药量亦不可不讲究也。魏生称谢。

（刘渡舟医案）

甘草汤类概述

甘草汤类共四方，即甘草汤、炙甘草汤、甘草附子汤、甘草干姜汤。甘草汤治少阴经中有热而咽喉疼痛，它有清阴中伏火与止痛解毒的作用。炙甘草汤治伤寒心动悸、脉结代，这是伤寒内挟心虚，而气血不足所致。甘草附子汤治骨节掣痛、屈伸不利、短气、小便不利等证。甘草干姜汤则治误汗肢厥，阳气受伤之证。

甘草性平，生用则能清热解毒，炙用则能补中益气，故少阴病的甘草汤是用生草而不用炙草。

一、甘草汤

【药物组成】

生甘草二两

【煎服法】

上一味，以水三升，煮取一升半，去滓温服七合，日二服。

【适应证】

治少阴阴中伏火，循经上犯，而使咽喉疼痛不休。

【原文】

第311条。

【方义】

生甘草味甘偏凉，善能泻少阴阴中之伏热而治咽喉肿痛，确有消肿解毒的良好作用。

【选注】

柯韵伯：“少阴之脉循喉咙、挟舌本，故有咽痛证。若因于他症而咽痛者，不必治其咽。如脉阴阳俱紧，反汗出而吐利者，此亡阳也，只回其阳，则吐利止而咽痛自除。如不利而胸满心烦者，是下焦虚而上焦热也，升水降火，上下和调而痛自止。若无他症而但咽痛者，又有寒热之别。见于二三日，是阴火上冲，可与甘草汤，甘凉泻火以缓其热；不瘥者，配以桔梗，兼辛以散之，所谓奇之不去而偶之也。”

【按语】

《伤寒论》112方，其中有甘草者不下七十方，甘草之治，可云溥矣。本方用生甘草一味，入少阴经清热解毒，而又不损伤正气，可见药味的炮制不同，则功效迥异。遣方用药，所不可不知也。

生甘草之清热解毒的作用，后世医家极为重视。如《圣济总录》云：“甘草汤治热毒肿，或身生瘰浆”。徐彬云：“甘草一味单行，最能和阴而清冲任之热。每见生便痛者，骤煎四两，顿服立愈。”可见甘草能清少阴客热之邪。

【方歌】

甘草名汤咽痛求，生用一两不多收；
莫道此是中焦药，清解少阴效最优。

【医案选录】

鄱阳徐刚，忽患右足赤肿，三日不能履地，医治无效。才服此药，须臾之间，即能移步，再服痊愈。

（摘《洪氏集验方》）

二、炙甘草汤

【药物组成】

甘草（炙）四两 生姜（切）三两 人参二两 生地黄一斤 桂枝（去皮）三两 阿胶二两 麦门冬（去心）半升 麻仁半斤 大枣（擘）三十枚

【煎服法】

上七味，以清酒七升，水八升，先煮八味取三升，去滓，内胶烊消尽。温服一升，日三服。（一名复脉汤）

【适应证】

此方治疗心之气血双虚，出现脉结代，心动悸等证。

【原文】

第177条。

【方义】

气血两虚，心脉失养，用炙甘草、人参、大枣补中益气，加强生化之源，且可通脉安神养心；生地、麦冬、麻仁、阿胶润燥滋液，补血生津；桂枝、生姜、清酒助阳气以行药力而通血脉。

【选注】

周禹载：“本条不言外证，寒热已罢可知；不言内证，二便自调可知。第以病久正气大亏，无阳以宣其气，更无阴以养其心，此脉结代、心动悸所由来也。方中人参、地黄、阿胶、麦冬、大枣、麻仁皆柔润之品以养阴，必得桂枝、生姜之辛以行阳气，而结代之脉乃复。尤重在炙草一味，主持胃气以资脉之本源。佐以清酒，使其捷行于脉道也。其煮法用酒七升、水八升，只取三升者，以煎良久，方得炉底变化之功，步步是法。要之，师第言结代者，用此以复之，非谓脉脱者以此方救之也。学者切不可泥其方名，致误危证，推之制生脉散，亦因其命名太夸，庸医相沿，贻害岂浅鲜哉？”

【按语】

《名医别录》云：“甘草通经脉，利血气”。由此观之，此方专以甘草为君，深得用药之旨。方虽气血双补，然偏重在于养阴。柯琴说：“大剂以峻补真阴，开来学滋阴之一路也。”此说颇获余心。本方久服，则出会现浮肿、腹泻等象，应该予以注意。

【方歌】

炙甘草汤少阴虚，心悸脉结证无疑；
麦地麻胶桂姜枣，清酒与水煎法奇。

【医案选录】

一人年五十余，中气本弱。至元庚辰，六月中病伤寒八九日。医见其热甚，以凉剂下之，又食梨三四枚，痛伤脾胃，四肢冷，时昏愤。罗诊之，其脉动而中止，有时自还，乃结脉也。心亦悸动，吃噫不绝，色变青黄，精神减少，目不欲开，蜷卧恶人语，以炙甘草汤治之。成无己云：补可去弱，人参、大枣之甘，以补不足之气；桂枝、生姜之辛，以益正气；五脏痿弱，荣卫涸流，湿剂所以润之，故用麻仁、阿胶、麦门冬、地黄之甘，润经养血，复脉通心是也。加桂枝、人参急扶正气，生地黄减半，恐伤阳气。剉一两剂服之，不效。罗再思脉病对，莫非药陈腐而不效乎？再于市铺选尝气味厚者，再煎服之，其病减半，再服而愈。

（摘自《名医类案》）

三、甘草附子汤

【药物组成】

甘草（炙）二两 附子（炮、去皮、破）二枚 白术二两 桂枝（去皮）四两

【煎服法】

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。初服得微汗则解，能食汗止复烦者，将服五合。恐一升多者，宜服六七合为始。

【适应证】

骨节疼痛剧烈，掣痛、屈伸不利、拒按，汗出，恶风，短气，小便不利，或身微肿。

【原文】

第175条。

【方义】

附子扶阳温经散寒，白术健脾运湿，桂枝通阳祛风，炙甘草补中益气。

【选注】

章虚谷：“此脾胃营卫皆虚，而阴邪痹结也。寒胜为痛痹，风胜为行痹，湿邪凝滞风寒而成。烦疼掣痛者，风也；不得屈伸，近之痛剧者，寒也；汗出而邪不去，恶风不欲去衣，营卫虚极矣。短气、小便不利、身微肿者，脾肾两虚，三焦气化无权，升降不利也。表里皆虚，邪痹不出，故以术、附、甘草大补脾肾之阳，而佐桂枝通经脉，不散其邪而风寒湿自去矣。”

【按语】

对本方证的认识有两种意见。以《医宗金鉴》为代表的，则拘于条文中“风湿”二字，认为本方是祛风湿之邪的汗剂。以章虚谷为代表的，

则认为本证是脾肾两虚，营卫虚极，表里皆虚，邪痹不出，本方是大补脾肾之阳，不必散邪而寒湿自去。我们认为章氏的说法是比较正确的。本方共四味药，附子配白术，而有术附汤之义，用以扶阳气而驱寒湿，故能治身体痛、骨节痛。桂枝配甘草，即桂枝甘草汤之义，用以振奋心阳，而治短气与小便不利。所以，从小便不利、汗出恶风、短气等证来看，本证实为风寒湿三邪伤于心脾肾三脏，正虚而邪恋。至于方后注云：“得微汗出则愈”，并非桂枝发汗的作用。尤在泾说得好：“云得微汗则解者，非正发汗也，阳复而阴自解耳。”其说当从。

【方歌】

甘草附子汤四味，桂枝白术药方备；
骨节掣痛不可近，恶风短气阳虚最。

【医案选录】

杨某，男，42岁，煤矿工人。患关节炎已三年，最近加剧，骨节烦疼，手不可近，并伴有心慌气短、胸中发憋，每到夜晚则尤重。切其脉缓弱无力，视其舌胖而嫩。辨为心肾阳虚，寒湿留于关节之证。为疏：

附子15克，白术15克，桂枝10克，炙甘草6克，茯苓皮10克，苡米10克。

服三剂而痛减其半，心慌等证亦佳。转方用桂枝去芍药加附子汤，又服三剂，则病减其七。乃书丸药方而治其顽痹获愈。

（刘渡舟医案）

四、甘草干姜汤

【药物组成】

甘草（炙）四两 干姜二两

【煎服法】

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

【适应证】

汗伤脾阳，寒从中生，证见呕吐与手足厥冷。

【原文】

第29条、30条。

【方义】

干姜辛热，温中去寒；炙草甘温，补中扶虚。然甘草剂量大于干姜一倍，意在温中回阳而又不伤下焦之阴，方无碍于两脚拘挛之证。

【选注】

成无己：“《内经》曰：辛甘发散为阳。甘草干姜相合，以复阳气。”

【按语】

古人对阴阳两虚之证，在治法上往往扶阳在先，滋阴在后，故本证先用甘草干姜汤以复其阳，阳生则阴长，阳固而阴始存。然本证脚挛急、咽干等阴伤之象，在回阳时亦不能不加考虑。为此，本方甘草倍于干姜，取甘大于辛，而后才能扶阳而不耗阴。后世医家治脾阳虚衰，不能统血而大便下血之证，用本方温脾以摄血，并把干姜改为炮姜，而取得了疗效。如《直指方》用本方治“男女诸虚出血”，《朱氏集验方》称本方为“二神汤”，治吐血极妙。这都是指温脾摄血而言的。若阳热亢盛，迫血妄行之出血，则实非本方所宜。

本方又治虚寒肺痿，由于肺冷气沮，津液不化，上不制下，而口中吐涎、头眩遗尿、溲数等证甚效。

【方歌】

甘草干姜两药齐，温肺运脾暖四肢；
金匱用以治肺痿，咳唾多涎尿也遗。

【医案选录】

王某，男，年50岁，贫农，1965年4月12日初诊。患者昨日下午开始眩晕欲吐，曾请医诊治，服清眩丸未愈。今脉迟（47次/分），舌淡欲吐，口不渴，无热，体温36.4℃，不怕冷。诊为寒证，治以温散，投予甘草、干姜各三钱，煎汤温服一剂。次日复诊，眩晕止，欲吐停，脉67次/分，出工筑墙。嘱再服原方一剂，后未复发。

（摘《中医杂志》1965，11）

苓桂术甘汤类概述

苓桂术甘汤类，包括了苓桂术甘汤、苓桂枣甘汤、苓桂姜甘汤和五苓散四个方剂。此四方皆以苓桂为名，皆有通阳化饮，下气利水的作用。苓桂术甘汤治心脾两虚，水气上冲的“心下逆满，气上冲胸，起则头眩”等证。苓桂枣甘汤则治心虚于上，水动于下的“脐下悸，欲作奔豚”等证。苓桂姜甘汤（即茯苓甘草汤）则治水蓄于胃的心下悸等证。五苓散则治水蓄膀胱的小便不利和消渴、水逆等证。

除以上四方证外，还论述了少阴阴虚有热的猪苓汤证，以及水在皮下，发热不解的文蛤散证。这两个方子虽与苓桂剂类有别，但对行水散结，敷布津液则有异曲同工之美。

一、茯苓桂枝白术甘草汤

【药物组成】

茯苓四两 桂枝（去皮）三两 白术 甘草（炙）各二两

【煎服法】

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

【适应证】

水气上冲，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧等证。

【原文】

第67条。

【方义】

本文为温中降逆，化饮利水之剂。茯苓淡渗利水以行饮，白术健脾以制水逆，桂枝通阳消阴、理气降冲，合茯苓则能伐水下行；合甘草则

助心阳以治悸。

【选注】

尤在泾：“此伤寒邪解而饮发之证。饮停于中则满，逆于上则气冲而头眩，入于经则身振振而动摇。《金匱》云：膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，其脉沉紧。又云：心下有痰饮，胸胁支满，目眩。又云：其人振振身

剧，必有伏饮是也。发汗则动经者，无邪可发，而反动其经气。故与茯苓、白术以蠲饮气，桂枝、甘草以生阳气。所谓病痰饮者，当以温药和之也。”

《医宗金鉴》：“身为振振摇者，即战振身摇也。身振振欲擗地者，即战振欲坠于地也。二者皆为阳虚失其所恃，一用此汤，一用真武者，盖真武救青龙之误汗，其邪已入少阴，故主以附子，佐以生姜苓术，是壮里阳以制水也。此汤救麻黄之误汗，其邪尚在太阳，一主以桂枝，佐以甘草苓术，是扶表阳以涤饮也。至于真武汤用芍药者，里寒阴盛，阳衰无依，于大温大散之中，若不佐以酸敛之品，恐阴极格阳，必速其飞越也。此汤不用芍药者，里寒饮盛，若佐以酸敛之品，恐饮得酸，反凝滞不散也。”

【按语】

心脾阳气虚衰，水气乘而上逆，则见心下逆满、气上冲胸、起则头眩、脉沉紧等证。本方温中降逆，化饮利水，使饮邪得除，则诸证自解。然本方辨证关键在于“气冲”一证，亦不可不知。

本方用于临床时，可以随证加减。如痰多脉滑的，可与二陈汤配合使用；如头眩较重的，可加泽泻；若头面有烘热之象的，可加白薇；若血压偏高的，可加红花、茜草、益母草、牛膝；若脉见结代，则减去白术而加五味子；若湿痰作咳，则减去白术而加苡米；若见惊悸不安的，可加龙骨、牡蛎。

【方歌】

苓桂术甘温药方，气上冲胸水为殃；
头眩心悸阴邪重，咳嗽短气功效彰。

【医案选录】

吴某，男性，36岁，1961年11月15日就诊。主诉：夏间上山砍柴，

劳动归来，汗流口渴，傍晚饮冷水两碗，翌晨，中脘突觉不舒。历旬余，渐感呼吸频促，继则短气似喘，胸胁支满，目眩，食欲减退，精神萎靡，小便欠畅，如此缠绵数月。经当地医生以肾气丸等药治疗，症反加剧，遂前来求治。诊脉沉弦而滑，舌苔垢。认为水饮内停为患。治拟健脾燥湿，利水蠲饮，用苓桂术甘汤加姜枣主之。

处方：茯苓五钱，桂枝二钱，白术五钱，甘草一钱五分，生姜三片，大枣三枚。水煎服，连服两剂。

11月17日二诊：服药后，气急稍平，小便略通，仍照前法加重剂量与之。

茯苓一两二钱，桂枝三钱，白术一两，甘草三钱，生姜三片（连皮），大枣七枚。

11月19日三诊：上药服后，舌苔已净，脉象转缓，小便通利，胸闷、目眩、短气等证消失，食量亦增。以素体虚弱，照原方加党参五钱、炙黄芪五钱，嘱连服五剂以善其后。

（摘《福建中医药》1960，5：36）

二、茯苓桂枝甘草大枣汤

【药物组成】

茯苓半斤 桂枝（去皮）四两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十五枚

【煎服法】

上四味，以甘澜水一斗，先煮茯苓减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

作甘澜水法：取水二斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。

【适应证】

心阳不足于上，下焦水寒之邪将欲发作成为奔豚。其证脐下悸动不安，抑或奔豚已发，而气冲心胸亦可服用。

【原文】

第65条。

【方义】

本方为心阳不足，寒水之邪欲作奔豚而设。重用茯苓伐水邪之上逆；桂枝通阳下气，以制阴邪之逆；甘草、大枣健脾培土，以防水泛。且桂甘相合，又能上补心阳；苓枣相合，则利水而不伤津。

【选注】

柯韵伯：“发汗后，心下悸欲得按者，心气虚而不自安，故用桂枝甘草汤以补心。若脐下悸欲作奔豚者，是肾水乘心而上克，故制此方以泻肾。豚为水蓄，奔则昂首疾驰，酷肖水势上攻之象，此证因以为名。脐下悸时，水气尚在下焦，欲作奔豚之兆而未发也，当先其时而急治之。君茯苓之淡渗，以伐肾邪；佐桂枝之甘温，以保心气；甘草、大枣培土以制水，亢则害者，承乃制矣。澜水状似奔豚，而性则柔弱，故又名“劳水”。用以先煮茯苓，水郁折之之法。继以诸甘药投之，是制以所畏，令一惟下趋耳。”

【按语】

人的生理是心火下暖肾水，肾水上济心火。若心火不足，不能坐镇于上，肾水不暖，则下焦水寒之气横行无忌，而反上凌于心。本病重点在于心火之不足，故重用桂枝温补心阳而行气化，又重用茯苓以泻水邪，以成标本兼顾之方；白术、甘草则崇土以防水上而已。

【方歌】

苓桂枣甘伏水邪，脐下悸动用则确；
或者上冲发奔豚，甘澜水煮效方捷。

【医案选录】

张某，男，54岁。主诉：脐下跳动不安，小便为难，有气从小腹上冲，至胸则心慌气闷、呼吸不利而精神恐怖。每日发作四、五次，上午轻而下午重。切其脉沉弦略滑，舌质淡，苔白而水滑。

辨证：此证气从少腹上冲于胸，名曰“奔豚”。乃系心阳上虚，坐镇无权，而下焦水邪得以上犯。仲景治此证有二方，若气冲而小便利者，用桂枝加桂汤；气冲而小便不利者，则用茯苓桂枝甘草大枣汤。今脐下悸而又小便困难，乃水停下焦之苓桂枣甘汤证。

疏方：茯苓30克，桂枝10克，上肉桂6克，炙甘草6克，大枣15枚。用甘澜水煮药。仅服三剂，则小便畅通而病愈。

（刘渡舟医案）

三、茯苓甘草汤（苓桂姜甘汤）

【药物组成】

茯苓三两 桂枝（去皮）二两 甘草（炙）一两 生姜（切）三两

【煎服法】

上四味，以水四升，煮取二升，去滓，分温三服。

【适应证】

胃中停水，心下作悸，或见肢厥，或见下利。

【原文】

第73条、356条。

【方义】

水停中焦，饮气相搏，若阻遏胃阳不达四肢，则四肢厥冷而心下悸。本方重用生姜温胃散饮，茯苓淡渗行饮，桂枝通阳化气，甘草扶中补虚，合为温胃化饮，通阳散水之剂。

【选注】

徐大椿：“此方之义，从未有诠释者。汗出之后而渴不止，与五苓人所易知也，乃汗出之后并无渴证，又未指明何证，忽无端而与茯苓甘草汤，此意何居？要知此处汗出二字，乃发汗后，汗出不止也。汗出不止则有亡阳在，即当以真武汤；其稍轻者，当与茯苓桂枝白术甘草汤；更轻者，则与此汤。何以知之？以三方同用茯苓知之。盖大汗泄，必引肾水上泛，非茯苓不能镇之，故真武则佐以附子回阳；此二方则以桂枝甘草敛汗，而茯苓则皆以为主药，此方义不了然乎？”

【按语】

本方为苓桂术甘汤去白术加生姜。前者重在补，后者重在散。因水邪内停于胃，并非下焦阳气式微之可比，所以在苓桂的基础上，又加生姜之辛健胃散水。俾水饮得去，阳气得通，则诸证自愈。

本方生姜的剂量一定要大，使之既可温胃散寒降逆，又可通气化

饮。

【方歌】

茯苓甘草与桂姜，胃中停水悸为殃；
气趋小腹或成泄，健胃泄水厥亦良。

【医案选录】

阎某，男，26岁。心下跳动不安，三、五日必发生一次腹泻，泻则悸轻。然不数日，证又复初。脉弦，而小便尚可，舌苔白滑。辨为胃中停饮，饮与气搏之证。若胃中之饮下趋肠间，则大便作泻而胃饮则减，证候随之而轻。然巢穴犹在，去而旋生，则又悸动不安。为疏：茯苓24克，生姜24克，桂枝10克，炙甘草6克。

服药十余剂，逐渐而安。

（刘渡舟医案）

四、五苓散

【药物组成】

猪苓（去皮）十八铢 泽泻一两六铢 白术十八铢 茯苓十八铢 桂枝（去皮）半两

【煎服法】

上五味，捣为散，以白饮和服方寸匕，日三服。多饮暖水，汗出愈。如法将息。

【适应证】

太阳蓄水证，小便不利，少腹胀满，烦渴而饮水不解，甚至水入则吐，或兼微热、汗出、恶风，或心下痞而小便不利，苔白，脉浮或弦。

【原文】

第71条、72条、73条、74条、141条、156条、244条、386条。

【方义】

本方桂枝通阳化气，兼解肌表之邪；白术补脾燥湿；茯苓利水行津；猪苓、泽泻助茯苓利小便以行津液。此方发汗以利小便，使外窍通而下窍利，故为表里双解之方。

【选注】

张锡驹：“散者，四散之意也。茯苓、泽泻、猪苓淡味而渗泄者也，白术助脾气以转输，桂枝从肌达表，外窍通而内窍利矣，故曰多饮暖水，汗出愈也。”

【按语】

蓄水证反见烦渴何耶？此乃气不化津，水蓄膀胱，故以小便不利为辨。本方重在通阳化气以行水液，无论有无表证，凡气化失常，而水蓄膀胱者，即可使用。若无表证，桂枝亦可改为肉桂。本方治霍乱吐泻，头痛发热，身疼痛，热多而欲饮水者，用之有效。

本方亦有利湿之效。后世医家治湿病多以五苓散加减，如茵陈五苓

散治湿多热少的黄疸之病。若与平胃散合方，名胃苓汤，治湿盛的大便濡泻。若加苍术、附子，名苍附五苓散，治阳虚而寒湿内盛的腰膝冷痛，腿酸踝肿等证。若加人参，名春泽煎，治老人正气虚衰，少气懒言，心悸息短，晨起而目胞肿。若加姜枣，又治风湿疫气等证。

【方歌】

五苓苓桂泽猪术，水停膀胱津不输；
口渴心烦尿不利，饮入则吐脉来浮。

【医案选录】

某生之父，素有饮茶之癖，日久化为湿痰，咳呕痰多，频吐不尽。自拟二陈汤，虽有好转，终不根治。我语生曰：治当通阳利小便，方能除其痰根。疏五苓散加化痰之品，随手而愈。

（刘渡舟医案）

五、猪苓汤

【药物组成】

猪苓（去皮） 茯苓 泽泻 阿胶 滑石（碎） 各一两

【煎服法】

上五味，以水四升，先煮四味取二升，去滓，内阿胶烱消，温服七合，日三服。

【适应证】

治心烦不得眠，口渴欲饮水，小便不利，发热，或咳、或呕、或下利，舌质红、苔水滑，脉弦细而数。

【原文】

第223条、224条、319条。

【方义】

猪苓淡渗利水，又能入肾以清热；茯苓健脾渗湿，又能入心以宁神；滑石清热以利六腑之邪，泽泻利水而滋阴精之虚。此方在清热利水中，妙在加阿胶血肉有情之品，取其味厚以滋补少阴。由此可见，此方为少阴阴虚有热而水邪不解者设。

【选注】

《医宗金鉴》：“赵羽皇曰：仲景制猪苓一汤，以行阳明、少阴二经水热。然其旨全在益阴，不专利水。盖伤寒表虚，最忌亡阳，而里虚又患亡阴。亡阴者，亡肾中之阴与胃家之津液也，故阴虚之人，不但大便不可轻动，即小水亦忌下通。倘阴虚过于渗利，则津液反致耗竭。方中阿胶质膏，养阴而滋燥；滑石性滑，去热而利水；佐以二苓之渗泻，既疏浊热而不留其壅瘀，亦润真阴而不苦其枯燥，是利水而不伤阴之善剂也。”

【按语】

本方所治小便不利，系阴分不足，水热相因所致。而真武汤的小便

不利，是肾阳虚而水邪泛滥为患，两方对照发挥，而有阴虚阳虚之别，寒热之辨，临床鉴别不难。

本证的小便不利，还包括尿道涩痛以及小便带血等证。如《类聚方广义》云：“猪苓汤治淋疾点滴不通，阴头肿痛。若茎中痛出脓血者，兼用硝石矾石散。”

【方歌】

猪苓汤治少阴虚，热与水蓄烦呕居；

小便不利口又渴，泽胶猪茯及滑石。

【医案选录】

崔某，女，35岁。因产后患腹泻，误以为虚，屡进温补，并无实效。切其脉沉而略滑，视其舌色红绛，而苔薄黄。初诊以其下利而又口渴，作厥阴下利治之，投白头翁汤不甚效。一日又来诊治，自述睡眠不佳，咳嗽而下肢浮肿，小便不利，大便每日三四次，口渴欲饮水。倾听之后，思之良久，乃恍然而悟，此乃猪苓汤证。《伤寒论》第319条说：“少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。”今呕咳下利主证已见，治当无疑。遂处方：猪苓10克，茯苓10克，泽泻10克，滑石10克，阿胶10克。此方服五剂，而小便利，腹泻止，诸证悉蠲。

（刘渡舟医案）

六、文蛤散

【药物组成】

文蛤五两

【煎服法】

上一味为散，以沸汤和一方寸匕，服汤用五合。

【适应证】

太阳病表不解，阳郁发热，不用汗法，反用冷水澀灌劫热，则身被寒劫，而弥更益烦，肉上粟起，口渴而不欲饮。

【原文】

第141条。

【方义】

以冷水劫热，使表阳郁而不宣，水邪反郁于皮下，故身热不解，而肉上粟起。文蛤能清热利水，以行体表之水，可使水热并解。

【选注】

尤在泾：“病在阳者，邪在表也，当以药取汗。而反以冷水澀之，或灌濯之，其热得寒被劫而不得竟去，于是热伏水内，而弥更益烦。水居热外，而肉上粟起。而其所以为热，亦非甚深而极盛也，故意欲饮水而口反不渴。文蛤咸寒而性燥，能去表间水热互结之气。若服之而不差者，其热渐深，而内传入本也。五苓散辛散而淡渗，能去膀胱与水相得之热。”

【按语】

柯韵伯认为：文蛤散应改为《金匱》的文蛤汤，此说有失仲景之义。若如柯氏所言，则“若不差者，与五苓散”之文字，便无着落。文蛤，即海蛤。《医宗金鉴》称文蛤为五倍子非是。甄权说：“治水气浮肿，下小便”，本方所用，正取此义。

【方歌】

水滸原逾汗法门，肉上粟起更增烦；
意中思水还无渴，文蛤磨调药不繁。

黄芩黄连汤类概述

黄芩黄连汤类，包括黄芩汤、黄芩加半夏生姜汤、黄连汤、黄连阿胶汤四方。

芩连皆为苦寒清热之品，然黄芩剂又有清热利胆与清热降逆之分，黄连剂又有清上温下与泻火滋水的不同。例如：黄芩汤为治太少合病的下利证；黄芩加半夏生姜汤则治太少合病，胃气上逆的呕吐证。黄连汤治胸中有热，胃中有邪气的呕吐下利证；黄连阿胶汤则治少阴阴虚于下，火炎于上的心烦不得卧寐之证。

一、黄芩汤

【药物组成】

黄芩三两 芍药二两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

【适应证】

太阳与少阳合病，发热口苦，下利急迫，腹痛，肛门灼热，舌苔黄，脉弦数。

【原文】

第172、333条。

【方义】

黄芩清泄少阳邪热，兼清大肠之热，故为君；芍药调血和肝而敛阴，故为臣；甘草缓急止痛，大枣和中养液，故为佐使。

【选注】

柯韵伯：“太阳少阳合病，是热邪陷入少阳之里，胆火四逆，移热于脾，故自下利。此阳盛阴虚，与黄芩汤苦甘相济以存阴也。凡太少合病，邪在半表半里者，法当从柴胡桂枝加减。此则热淫于内，不须更顾表邪，故用黄芩以泄大肠之热，配芍药以补太阴之虚，用甘枣以调中州之气。”

【按语】

合病下利，所见有三：即太阳阳明合病下利、阳明少阳合病下利、太阳少阳合病下利。三者虽皆见下利之证，但病机治法却截然有别。太阳阳明合病，自下利为在表，当与葛根汤发汗；阳明少阳合病，自下利为在里，可与承气汤泻下。此太阳少阳合病，自下利为在半表半里，非汗下所宜，故与黄芩汤，以清解半表半里之邪。

【方歌】

黄芩汤治太少利，腹痛急迫脉弦细；

黄芩白芍甘草枣，清热和阴平肝逆。

【医案选录】

王某，男，28岁。初夏迎风取爽，而头痛身热，医用发汗解表药，热退身凉，头痛不发，以为病已愈。又三日，口中甚苦，且有呕意，而大便下利黏秽，日四五次，腹中作痛，且有下坠感。切其脉弦数而滑，舌苔黄白相杂。辨为少阳胆热下注于肠而胃气不和之证。药用：黄芩10克，白芍10克，半夏10克，生姜10克，大枣7枚，甘草6克。

服三剂而病痊愈。

（刘渡舟医案）

二、黄芩加半夏生姜汤

【药物组成】

黄芩三两 芍药二两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚 半夏（洗）半升 生姜（切）一两半（一方三两）

【煎服法】

上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

【适应证】

黄芩汤证又兼呕吐。

【原文】

第172条。

【方义】

黄芩汤清热止利如上所述，加半夏、生姜和胃降逆止呕。

【选注】

尤在泾：“太阳少阳合病者，其邪近里，治之使从里和为易……夫热气内淫，黄芩之苦可以清之。肠胃得热而不固，芍药之酸、甘草之甘可以固之。若呕者，热上逆也，故加半夏、生姜以散逆气。而黄芩之清里，亦法所不易矣。”

【按语】

后世对本方的应用范围有所推广，如王孟英治体虚伏热之霍乱，张路玉用治伏气发湿，内挟痰饮，痞满咳逆；薛立斋用治胆腑发咳，呕水如胆汁等。录之以供参考。

【方歌】

黄芩原方加夏姜，呕吐下利胃肠伤；太少合病邪热淫，苦降辛开治少阳。

三、黄 连 汤

【药物组成】

黄连三两 甘草（炙）三两 干姜三两 桂枝（去皮）三两 人参二两 半夏（洗）半升 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服，昼三夜二。

【适应证】

治胸中有热，胃中有寒，时欲呕吐，腹中疼痛，大便下利等证。

【原文】

第173条。

【方义】

黄连苦寒，以清心胸之热，并能厚肠胃以止利，故为方中主药。干姜辛热，以温中寒。二药相伍，辛开苦降，治寒清热，各行其是。半夏降逆止呕；桂枝通阳降冲；人参、大枣补中益气；甘草和胃，且有协调诸药之功。

【选注】

《医宗金鉴》：“君黄连以清胃中之热；臣干姜以温胃中之寒；半夏降逆，佐黄连呕吐可止；人参补中，佐干姜腹痛可除；桂枝所以安外，大枣所以培中也。然此汤寒温不一，甘苦并投，故必加甘草协和诸药。此为阴阳相格，寒热并施之治法也。”

尤在泾：“此上中下三焦俱病，而其端实在胃中。邪气，即寒淫之气。胃中者，冲气所居，以为上下升降之用者也。胃受邪而失其和，则升降之机息，而上下之道塞矣。成氏所谓阴不得升而独治其下，为下寒腹中痛；阳不得降而独治于上，为胸中热欲呕吐者是也。故以黄连之苦寒以治上热，桂枝之甘温以去下寒。上下既平，升降乃复。然而中焦不治，则有升之而不得升，降之而不得降者矣。故必以人参、半夏、干姜、甘草、大枣以助胃气而除邪气也。”

【按语】

本方系半夏泻心汤减黄芩加桂枝而成。两方之药仅一味之差，而主治则各有不同。半夏泻心汤证是寒热痞结于中，有心下痞满，呕吐下利，故姜夏与芩连并用，以解寒热互结之证。黄连汤证是上热呕吐，下寒腹痛而利，然中无痞证，故重用黄连清热于上，桂枝、干姜通阳散寒于下，从而使上下阴阳寒热各得其所则愈。

【方歌】

黄连汤内参连草，姜桂半夏和大枣；
胃中有寒心胸热，呕吐腹痛此方宝。

【医案选录】

陈襄人，男，25岁。久泻愈后，又复呕吐，医进参、术、砂、半，复进竹茹、麦冬、芦根，诸药杂投无效。其证身微热，呕吐清水，水入则不纳，时有冲气上逆，胸略痞闷，口不知味，舌光红燥，苔腻不渴，脉阴沉迟而阳浮数，乃上热中虚之证，应用黄连汤。方中姜、桂、参、草温脾胃而降冲逆，黄连清胸热，伴半夏以止呕吐，为一寒一热错综之良方。服药呕吐渐止；再剂，证全除，能进稀粥。后用五味异功散加生姜，温胃益气而安。

（摘自《赵守真治验回忆录》）

四、黄连阿胶汤

【药物组成】

黄连四两 黄芩二两 芍药二两 鸡子黄二枚 阿胶三两（一云三挺）

【煎服法】

上五味，以水六升，先煮三物取二升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

【适应证】

心烦不得寐，舌尖红赤，苔薄黄，或舌红少苔，脉细数。

【原文】

第303条。

【方义】

黄连、黄芩清心火以下降；阿胶、鸡子黄为血肉有情之品，补血滋肾以上潮；芍药之酸，敛阴气而平肝。合为育阴泻火，交通阴阳之剂。

【选注】

成无己：“阳有余，以苦除之，黄连、黄芩之苦以除热；阴不足，以甘补之，鸡黄、阿胶之甘以补血；酸，收也，泄也，芍药之酸，收阴气而泄邪热。”

【按语】

本方所主系少阴热化证。多由心肾阴液先虚，病从热化，肾水不能上交心火所致。因其病机为阴虚有热，故既不宜单纯滋阴，更不可一味清热，应滋阴清热兼用，方为妥切。

本方滋肾阴补心血，清心火除烦热，治疗阴虚有热、心肾不交之心烦不得眠，以及久利而兼见阴虚内热，常能收到满意的效果。

本方所设滋阴清热之法，对后世温病学的治疗产生了很大影响。

【方歌】

黄连阿胶治少阴，烦躁不寐脉数频；
舌尖如梅是的候，芩连芍胶黄搅匀。

【医案选录】

李某，男，43岁，北京人，某厂干部。

主诉：于1978年10月，无明显诱因而自觉双下肢发凉。厂医诊为肾阳虚证，用了金匱肾气丸、虎骨酒、青娥丸等大量温补之药，而病情未能控制，仍逐渐发展。冷感向上至腰部，向下则冷至足心，如赤脚立冰上，寒冷彻骨。同时伴有下肢麻木、痒如虫行，小便余沥与阳痿等证。曾先后在北京医院、首都医院、友谊医院检查，均未见异常，而建议中医治疗。虽服补肾壮阳、益气和血等中药二百余剂，未能见效。于1980年1月11日转请刘渡舟教授诊治。患者素体健康，面部丰腴，两目有神，舌质色绛、少苔，脉弦而略数。问其饮食如故，大便不爽，小便短少而发黄。初投四逆散，按阳厥之证治之，药进三剂，厥冷依然。乃又反复追询其病情，患者才说出睡眠不佳，且多乱梦，而心时烦，容易汗出。视其舌尖红如杨梅，脉来又数，反映了阴虚于下而心火独旺于上之证。其证与黄连阿胶汤颇为合拍。《伤寒论》第303条云：“少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。”说明了水火阴阳不相交通的治则。此证因心火上炎，无水以承，是以心烦少寐，多梦汗出；火盛于上，阳气不能下达，使下肢不得阳气之温，上下阴阳不相顺接，是以为厥。四逆散疏气通阳而不能泻上盛之火，是以服药无效，乃疏下方治疗。

黄连9克，黄芩3克，白芍6克，阿胶9克（烔化），鸡子黄2枚（自加）。

上五味，以水三碗，先煮三物，取一碗，去滓，纳胶烔尽，小冷，纳鸡子黄，搅令相得，分两次服下。

服药三剂后，患者即觉下肢寒冷麻木之感逐渐消退，心烦、汗出、失眠多梦等证均有明显好转，小便余沥和阳痿亦有所改善。察其舌，仍红赤而少苔，脉弦而微数，继宗原法治之。处方：黄连9克，阿胶10克（烔化），黄芩8克，白芍9克，鸡子黄2枚（自加），丹皮6克。六剂，煎服法同前。

1月30日，适值降雪，寒风凛冽，但患者并无异常寒冷之痛苦，腰以下厥冷证基本告愈。

（摘自《中医杂志》1980，12：19）

白虎汤类概述

白虎汤类，包括白虎汤、白虎加人参汤、竹叶石膏汤三方。白虎汤治热在阳明气分，气分有热，则必伤津，故证见口渴引饮，大热汗出，脉洪大等证。因其人大便不秘，故不叫腑实证，又不见头痛恶寒，所以也不称经表证，而叫阳明病热证为宜。

白虎汤若加人参，则叫白虎加人参汤，是治疗阳明热盛而气阴两伤之证。例如：大烦渴而欲饮水数升，口燥渴而背微恶寒，或大汗烦渴而时时恶风等证。至于竹叶石膏汤，乃是白虎汤的变方，治疗热病后期，形体羸瘦，虚烦少气，气逆欲吐，而不能饮食等证。

一、白虎汤

【药物组成】

知母六两 石膏（碎）一升 甘草（炙）二两 粳米六合

【煎服法】

上四味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

此方治疗热邪充斥表里，一身大热，汗出而口渴欲饮，心烦，甚或谵语，神昏遗尿，或腹满身重，或身发热而四肢厥冷，舌质红绛，舌燥苔黄，脉洪大充盈，或滑数任按。

【原文】

第176、219、170、350条。

【方义】

石膏辛甘大寒，能清阳明气分之热，量大力专，故为主药；知母苦

寒而润，滋肺肾之阴而生津液，又能助石膏而清火热之邪；炙甘草补中益气；粳米养胃以滋化源，且制知母、石膏之悍而保胃气于中。

【选注】

柯韵伯：“白虎汤乃土中泻火而生津液之上剂也。石膏大寒，寒能胜热，味甘归脾，性沉而主降，已备秋金之体；色白通肺，质重而含津，已具生水之用。知母气寒主降，味辛能润，泄肺火而润肾燥，滋肺金生水之源。甘草土中泻火，缓寒药之寒，用为舟楫，沉降之性，始得留连于胃。粳米稼穡作甘，培形气而生津血，用以奠安中宫，阴寒之品，无伤脾损胃之虑矣。饮入于胃，输脾归肺，水津四布，烦渴可除也。”

【按语】

白虎汤善清气分之热而效如桴鼓，无论伤寒还是温病，凡邪热不解，而大烦渴、脉洪大者，皆可任用。

石膏为白虎汤的主药，其量应因证因时而增损。余师愚在《疫疹一得》中，用石膏达二斤之多。清代的江笔花、近代的张锡纯都以重用石膏而著称。但石膏如果用之不当，也会带来不良的后果。如“伤寒脉浮，发热无汗，其表不解”，就不可以用白虎汤治疗。由此来看，用白虎汤用于烦渴一证，应予注意。

【方歌】

白虎烦渴用石膏，大热汗出脉滔滔；
知粳甘草四药足，清气生津润枯焦。

【医案选录】

江阴缪姓女，予族侄子良妇也。自江阴来上海，居小西门寓所。偶受风寒，恶风自汗，脉浮，两太阳穴痛，投以轻剂桂枝汤：计桂枝二钱、芍药三钱、甘草一钱、生姜二片、大枣三枚。汗出，头痛差，寒热亦止。不料一日后，忽又发热，脉转大，身烦乱，因与白虎汤：生石膏八钱、知母五钱、生草三钱、粳米一撮。服后，病如故。次日，又服白虎汤。孰知身热更高，烦躁更甚，大渴引饮，汗出如浆。又增重药量为：石膏二两、知母一两、生草五钱、粳米二杯，并加鲜生地二两、天花粉一两、大小蓟各五钱，丹皮五钱。令以大锅煎汁，口渴即饮。共饮三大碗，神志略清，头不痛，壮热退，并能自起大小便。尽剂后，烦躁亦安，口渴大减。翌日停药，至第三日，热又发，且加剧，周身骨节疼

痛，思饮冰凉之品，夜中令其子取自来水饮之，尽一桶。因思此证乍发乍止，发则加剧，热又不退，证大可疑。适余子湘人在，曰：论证情，确系白虎，其势盛，则用药亦宜加重，第就白虎汤原方，加石膏至八两，余仍其旧，仍以大锅煎汁冷饮。服后，大汗如注，湿透衣襟，诸恙悉除，不复发。

（摘《经方实验录》）

二、白虎加人参汤

【药物组成】

知母六两 石膏（碎、绵裹）一斤 甘草（炙）二两 粳米六合 人参三两

【煎服法】

上五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

凡白虎汤证而又有大渴，饮水不解，或时时恶风，或舌燥而背微恶寒，脉大而按之中空无力。

【原文】

第26、168、169、170、222条。

【方义】

白虎汤清阳明气分之热，加人参益气生津。此方为阳明气阴两伤而热盛不解者设。

【选注】

曹颖甫：“方用石膏、知母以除烦，生甘草、粳米加人参以止渴，此白虎汤加人参之旨也。”

【按语】

本方为白虎汤加人参。《本经》云：人参“补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸”。而五脏则属阴，反映了人参有补脏阴的作用。人参又能益脾肺之气，气足则津生，故加人参止渴生津，又能益气保元。

本方有“背微恶寒”一证，应与少阴病的“背恶寒”加以鉴别。一是“口中燥”，一是“口中和”。口中燥者，属白虎加人参汤证。

【方歌】

白虎加参气阴伤，烦渴脉大饮水浆；
汗出过多脉成芤，背微恶寒舌焦黄。

【医案选录】

从军王武经病，始呕吐，俄为医者下之，已八九日，而内外发热。予诊之曰：当行白虎加人参汤。或云既吐复下，是里虚矣，白虎可行乎？予曰：仲景云见太阳篇二十八证，若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热者，白虎加人参汤，证相当也。盖吐者，为其热在胃脘，而脉致令虚大，三投而愈。

（摘《伤寒九十论》）

三、竹叶石膏汤

【药物组成】

竹叶两把 石膏一斤 半夏（洗）半升 麦门冬（去心）一升 人参二两 甘草（炙）二两 粳米半升

【煎服法】

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟汤成，去米，温服一升，日三服。

【适应证】

热病后期，往往出现气阴两伤，形体消瘦，身热多汗，口渴喜饮，虚烦少气，不思饮食，气逆欲吐等证。其人舌红，或干瘦少苔，脉则虚数无力。

【原文】

第397条。

【方义】

竹叶甘淡而寒，凌冬不凋，秉阴气而生，能使水津上奉，导虚热以下行；石膏辛寒，清热生津。二药配伍，则清热除烦而又生津。人参益气以生津，炙草补中而扶虚，两药配伍，则补中益气，以扶正虚。麦冬甘寒，而能大滋胃液，半夏辛润能降逆止呕，二药相反相成，既能行麦冬之滞，又能治胃逆之吐。粳米平补而滋胃气，使其清热而不伤胃，补虚而不留邪。

【选注】

《医宗金鉴》：“是方也，即白虎汤去知母加人参、麦冬、半夏、竹叶也。以大寒之剂易为清补之方，此仲景白虎变方也。经曰：形不足者，温之以气，精不足者，补之以味。故用人参、粳米补形气也；佐竹叶、石膏清胃热也；加麦冬生津，半夏降逆，更逐痰饮。甘草补中，且以调和诸药也。

钱潢：“竹叶性寒而止烦热，石膏入阳明而清胃热，半夏蠲饮而止

呕吐，人参补病后之虚，同麦冬而大添胃中之津液。又恐寒凉损胃，故用甘草和之，而又以粳米助其胃气也。”

【按语】

本方系白虎汤加减而成。古人用方贵在化裁，以曲应病情之变。考白虎汤以清热为主，生津为辅。而此方则以补益气阴为主，清热为辅。何以见之？两方用石膏则一，唯此方用麦冬而不用知母，彼则用知母而不用麦冬。麦冬功专补液，而知母则以清热为长。况麦冬又配半夏，降逆以止呕，竹叶配石膏，清热以除烦，故又不同于白虎汤之剂。此外，竹叶应以鲜者为佳。

根据临证观察，有多数妇女患急性化脓性乳腺炎，或自行破溃，或手术排脓后，而发热持续不退，神倦心烦，不思饮食，恶心欲吐，舌红无苔，脉数无力等，虽用多种抗生素治疗无效，反使病情加重。此时，若投以竹叶石膏汤则往往有效。因为足阳明之脉，“其直者从缺盆下乳内廉”，故乳腺炎破溃，累及阳明气阴两伤而使用本方实为理想。本方擅清余热，更益气津，是值得推荐的一张方子。

【方歌】

竹叶石膏气阴伤，病后虚羸呕逆方；
不欲饮食参草麦，粳叶石膏半夏匡。

【医案选录】

张某，女，25岁，昌黎县人。患乳腺炎已做手术，而发热至38.5℃，高则39.5℃。西医认为炎症所发，乃用各种抗菌药，皆无效可言。又用“安乃近”注射液，汗出甚多，而发热暂退，旋又上升。因几经发汗，而身体虚羸不堪，且呕吐不欲饮食，心烦，头晕，肢体震颤，口中干涸。余诊其脉，数软无力，舌质红而苔白黄。余问主治医李君：此何病耶？答曰：恐为败血病。然余则认为气阴两伤，胃中津液竭乏，故尔发生虚烦呕逆。

方用：生石膏30克，麦冬25克，炙甘草10克，半夏10克，粳米15克，竹叶10克，党参10克。

此方共服四剂，则热退呕止，而能饮食，其病因之而愈。

（刘渡舟医案）

承气汤类概述

承气汤类，包括调胃承气汤、小承气汤、大承气汤和麻子仁丸四方。调胃承气汤治阳明燥热初结在胃，而使胃气不和，可见谵语，蒸蒸发热，或不吐不下心烦等证。小承气汤治阳明病大便成硬而汗出较多，小便偏渗，或日晡潮热，脉反滑疾等证。大承气汤则治阳明病燥屎已成，潮热汗出，不恶寒反恶热，绕脐痛，或腹中胀满疼痛，谵语神昏，脉沉紧等证。麻子仁丸是由小承气汤加味而成，治胃强脾弱，迫津偏渗，小便数多而成脾约之证。

麻子仁丸方后，附有蜜煎导和猪胆汁导两种导法，则为欲大便而不出，肠燥而胃未实的一种措施。

一、调胃承气汤

【药物组成】

大黄（去皮、清酒洗）四两 甘草（炙）二两 芒硝半升

【煎服法】

上三味，以水三升，煮取一升，去滓，内芒硝，更上火微煮，令沸，少少温服之。

【适应证】

阳明病不大便，蒸蒸发热，濈濈汗出，或腹胀满，或心烦、谵语，其人舌苔黄燥，脉滑数。

【原文】

第29条、30条、70条、94条、105条、123条、207条、248条、249条。

【方义】

大黄苦寒泄热，芒硝咸寒润燥，凡苦咸寒之药，本为泻下而设，然方中又加一味炙甘草，则使硝黄缓留于上，以和胃气为主。至于泻下肠燥，乃属其次。故陈修园称本方为“法中之法”，即“调胃”与“承气”两者并行不悖之意。

【选注】

柯韵伯：“邪气盛则胃实，故用大黄、芒硝。此自用甘草，是和胃之意。此见调胃承气，是和剂而非下剂也。”

【按语】

本方治阳明病燥热在胃，大便虽秘而未成硬，所以用炙甘草以缓硝黄于上，则和胃与泻下两用。凡大便秘结，而火热于上者，此方最宜。

【方歌】

调胃承气用大黄，芒硝甘草三药尝；胃气不和心烦热，便燥谵语舌苔黄。

【医案选录】

李某长子，19岁。四月病伤寒九日，医作阴证治之，与附子理中丸数服，其证增剧。更医又作阳证，议论差互，不敢服药，决疑于罗。坐有数人，罗不欲直言其证，但细为分解，使自度之。凡阳证者，身须大热而手足不厥，卧则坦然，起则有力，不恶寒，反恶热，不呕不泻，渴而饮水，烦躁不得卧，能食而多语，其脉浮而数者，阳证也。凡阴证者，身不热而手足厥冷，恶寒蜷卧，恶闻人声，或自引衣盖，不烦渴，不饮食，小便自利，大便反快，其脉沉细而迟者，阴也。今诊其脉沉数，得六七至，夜叫呼不绝，全不睡，又喜饮冷冰水，阳证悉具。三日不见大便，宜急下。乃以：酒煨大黄六钱、炙甘草二钱、芒硝五钱，煎服。至夕，下数行，燥屎二十余块，是夜大汗出。明日又往视之，身凉脉静矣。

（摘自《罗谦甫医案》）

二、小承气汤

【药物组成】

大黄（酒洗）四两 厚朴（去皮炙）二两 枳实（大者炙）三枚

【煎服法】

上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。初服汤当更衣。不尔者，尽饮之。若更衣者，勿服之。

【适应证】

蒸蒸发热而多汗，或小便数多，则津液偏渗，大便成硬，证见烦躁，谵语，腹胀，舌苔黄厚，脉滑而疾。

【原文】

第208条、209条、213条、214条、250条、251条、374条。

【方义】

大黄苦寒，荡涤实热，攻下积滞，推陈致新；厚朴苦温，行气泄满；枳实苦寒，破结消痞。三药同煎而无芒硝，是为缓下之方。

【选注】

柯韵伯：“夫诸病皆因于气。秽物之不去，由于气之不顺，故攻积之剂必用行气之药以主之。亢则害，承乃制，此承气之所由。又病去而元气不伤，此承气之义也。夫方分大小，有二义焉。厚朴倍大黄，是气药为君，名大承气。大黄倍厚朴，是气药为臣，名小承气。味多性猛制大其服，欲令泄下也，因名曰大。味少性缓制小其服，欲微和胃气也，故名曰小。二方煎法不同，更有妙义。大承气用水一斗，先煮枳朴，煮取五升，内大黄，煮取三升，内硝者，以药之为性，生煮锐而先行，熟者气纯而和缓，仲景欲使芒硝先化燥屎，大黄继通地道，而后枳朴除其痞满，缓于制剂者，正以急于攻下也。若小承气则三物同煎，不分次第，而服只四合，以求地道之通，故不用芒硝之峻，且远于大黄之锐矣，故称为微和之剂。”

【按语】

小承气汤比大承气汤少芒硝，而枳朴的药量也轻，且又三药同煎，故为缓下之剂。虽主治阳明腑实证，而便不燥坚者为宜。

【方歌】

小承气汤朴枳黄，便硬谵语腹胀详；
识得燥结分轻重，脉滑不紧用此方。

【医案选录】

有人病伤寒八九日，身热无汗，时时谵语，时因下利，大便不通三日矣，非烦非躁，非寒非痛，终夜不得卧，但心中无晓会处，或时发一声如叹息之状。医者不晓是何证。予诊之曰：此懊_𢶏怫郁，二证俱作也。胃中有燥屎，宜承气汤。下燥屎二十余枚，得利而解。

（摘《普济本事方》第127页）

三、大承气汤

【药物组成】

大黄（酒洗）四两 厚朴（去皮炙）半斤 枳实（大者炙）五枚 芒硝三合

【煎服法】

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，更煮取二升，去滓，内芒硝，更上微火一两沸，分温再服。得下，余勿服。

【适应证】

阳明病不大便，潮热，手足濇然汗出，谵语，烦躁，腹胀满，绕脐痛、拒按，甚则神昏独语、如见鬼状，舌质红绛，舌苔老黄或焦燥有刺，脉沉实或沉迟有力。

【原文】

第208条、209条、212条、215条、217条、220条、238条、240条、241条、242条、251条、252条、253条、254条、255条、256条、320条、321条、322条。

【方义】

大黄苦寒，荡涤肠胃，泄热破结，推陈致新；芒硝咸寒，软坚化燥，并协同大黄排泻燥屎；厚朴苦温泄满，枳实苦寒消痞，二药通利肠胃之气，能助硝黄泻下燥屎。

【选注】

《医宗金鉴》：“诸积热结于里而成满痞燥实者，均以大承气汤下之也。满者，腹胁满急^臑胀，故用厚朴以消气壅；痞者，心下痞塞硬坚，故用枳实以破气结；燥者，肠中燥屎干结，故用芒硝润燥软坚；实者，腹痛大便不通，故用大黄攻积泻热。然必审四证之轻重，四药之多少适其宜，始可与也。若邪重剂轻，则邪气不服；邪轻剂重，则正气转伤，不可不慎也。”

【按语】

大承气汤为峻下之方，治疗痞、满、燥、坚、实俱备的阳明燥实证。硝黄泻下可去实，枳朴通气可去滞。四味合用，制大其服，通顺腑气，而有承上以继下，推陈以致新的作用，故曰大承气汤。

大黄久煮，则泻下作用减弱。本方先煮枳朴，后下大黄与芒硝，则能加强泻下的作用。若下后，按脐周围仍然硬痛，而舌黄未去，是下之未尽，可以重复泻下。

【方歌】

大承气汤用硝黄，厚朴枳实四药强；
潮热蒸蒸濇濇汗，腹满硬痛峻攻良。

【医案选录】

予尝诊江阴街肉庄吴姓妇人，病起已六七日，壮热，头汗出，脉大，便闭，七日未行，身不发黄，胸不结，腹不胀满，唯满头剧痛，不言语，眼胀，瞳神不能瞬，人过其前，亦不能辨，证颇危重。余曰：目中不了了，睛不和，燥热上冲，此《阳明篇》三急下证之第一证也。不速治，病不可为矣。于是，遂书大承气汤方与之：

大黄四钱，枳实三钱，川朴一钱，芒硝三钱。
并嘱其家人速煎服之。竟一剂而愈。

（摘自《经方实验录》）

四、麻子仁丸

【药物组成】

麻子仁二升 芍药半斤 枳实（炙）半斤 大黄（去皮）一斤 厚朴（炙去皮）一尺 杏仁（去皮尖、熬，别作脂）一升

【煎服法】

上六味，蜜和丸如梧桐子大，饮服十丸，日三服。渐加，以知为度。

【适应证】

趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则阴气弱，阳来逼阴，小便偏渗而数，大便因之则硬，名曰“脾约”证。

【原文】

第247条。

【方义】

方用麻仁、杏仁滋润胃肠之燥；芍药味酸，善调脾家之阴；大黄、厚朴、枳实具有承气汤的意义，用以泻胃之燥热；白蜜为丸，则使峻药缓行，达成润肠通便之法。

【选注】

程郊倩：“脾约者，脾阴外渗，无液以滋，脾家先自干槁了，何能以余阴荫及肠胃。所以，胃火盛而肠枯，大便坚而粪粒小也。麻仁丸宽肠润燥，以软其坚，欲使脾阴从内转耳。”

【按语】

脾约证的大便不通与三承气证不同。它无潮热、汗出、腹胀满痛等证，而是“不更衣十日无所苦”。临床上也可见到病人口臭，心烦，头晕等证。胃中燥热，不仅约束脾阴，又不能为胃行其津液，反逼迫津液偏渗，以致小便频数。肠燥无液，故尿小而硬，干结难通。

【方歌】

麻子仁丸效果好，大便秘结津液少；
枳朴大黄泻胃强，麻杏芍药滋脾约。

【医案选录】

一豪子郭氏，得伤寒数日，身热、头疼、恶风、大便不通，脐腹膨胀。易数医，一医欲用大承气，一医欲用大柴胡，一医欲用蜜导。病家相知凡三五人，各主其说，纷然不定，最后请余至。问小便如何？病家云小便频数。乃诊六脉，下及趺阳脉浮且涩。予曰：脾约证也，此属太阳阳明。仲景云：太阳阳明者，脾约也。仲景又曰：趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬。其脾为约者，大承气、大柴胡恐不当，仲景法中麻仁丸不可易也。主病亲戚尚尔纷纷，予曰：若不相信，恐别生他证，请辞，无庸召我。坐有一人，乃弟也，逡巡曰：诸君不须纷争，既有仲景证法相当，不同此说何据？某虽愚昧，请终其说，诸医若何，各请叙述。众医默默，纷争始定。余以麻仁丸百粒，分三服，食顷间尽。是夕，大便通，中汗而解。

（摘《伤寒九十论》证八十三）

五、蜜煎导方

【药物组成】

食蜜七合

【使用法】

上一味，于铜器内微火煎，当须凝如饴状，搅之勿令焦着，欲可丸，并手捻作挺，令头锐，大如指，长二寸许。当热时急作，冷则硬。以内谷道中，以手急抱，欲大便时乃去之。（疑非仲景意，已试甚良。）

六、猪胆汁灌方

【药物组成】

大猪胆一枚

【使用法】

又大猪胆一枚，泻汁，和少许法醋，以灌谷道内，如一食顷，当大便出宿食恶物，甚效。

【适应证】

上二方均适用于大便秘而尿色白，欲大便而又难出。

【原文】

第233条。

【方义】

蜜煎导法，对肠中津枯便结者为宜，乃润便通燥之法。猪胆汁灌肠，既导便外出，又能解毒清热，而两全其美。

【选注】

《医宗金鉴》：“阳明病，自汗出，或发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽大便硬而无满痛之苦，不可攻之，当待津液还胃，自欲大便，燥屎已至直肠，难出肛门之时，则用蜜煎润窍滋燥，导而利之，或土瓜根宣气通燥，或猪胆汁清热润燥，皆可为引导法，择而用之可也。”

【按语】

导法适合津亏便结，或初硬后溏，燥实未成，以及年迈体弱、阴血素亏而便秘不下者。应用时，当病者有自欲大便而又难出时，即导而通之为好。

【方歌】

蜜煎熟后样如饴，稍冷搓挺四寸余；

温纳肛门润肠燥，古法导便叹惊奇；
津亏有热便不出，猪胆一枚方相宜；
泻汁调醋灌肠内，虚家便秘见效奇。

【医案选录】

庚戌仲春，艾道先染伤寒，近旬日，热而自汗，大便不通，小便如常，神昏多睡。诊其脉长大而虚。予曰：阳明证也。乃兄景先曰：舍弟全似李大夫，证又属阳明，莫可行承气否？予曰：虽为阳明，此证不可下。仲景阳明自汗，小便利者，为津液内竭，虽坚不可攻，宜蜜兑导之，作三剂，三易之，先下燥粪，次泄溏，已而汗解。

（摘《伤寒九十论》证七）

门人张永年述其戚陈姓一证……陈姓始病咯血，其色紫黑，经西医用止血针，血遂中止。翌日，病者腹满困顿日甚，延至半月，大便不行，始用蜜导不行，用灌肠法又不行，复用一切通大便之西药，终不行。或告陈曰：同乡周某，良医也。陈喜，使人延周时，不大便已一月矣。周至，察其脉无病，病独在肠，乃令病家觅得猪胆，倾于盂，调以醋，借西医灌肠器以灌之。甫灌入，转矢气不绝。不逾时，而大便出，凡三寸许，掷地有声，击以石不稍损。乃浸以清水，半日许，盂水尽赤，乃知向日所吐之血，本为瘀血。因西医用针止住，反下结大肠而为病也。越七日，又不大便，复用前法，下燥屎数枚，皆三寸许，病乃告痊。

（摘《经方实验录》）

柴胡汤类概述

柴胡汤类共有七方，其中应以小柴胡汤为代表。小柴胡汤是和解少阳邪热的主方，它以口苦、咽干、目眩、心烦喜呕、往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、脉弦、舌苔白滑等为其主证。若在此基础上，兼阳明腑燥，大便秘结，心下急，呕不止的，则用大柴胡汤治疗。若但发潮热，而又胃气不和的，则用柴胡加芒硝汤治疗。若兼太阳之表不解，而发热恶风，四肢关节烦疼，呕而心下支结的，则用柴胡桂枝汤治疗。若兼见太阴里寒，气化不行，而见口渴不呕，小便不利，胸胁满微结，但头汗出等证，则用柴胡桂枝干姜汤治疗。若兼见谵语烦躁，惊怖不安，小便不利，周身困重，难以转侧等证，则用柴胡加龙骨牡蛎汤治疗。若因阳气内郁，肝胆疏泄不行，而见手足厥冷，胸胁苦满，心下痞塞，下利后重等证，则用四逆散治疗。

一、小柴胡汤

【药物组成】

柴胡半斤 黄芩三两 半夏（洗）半升 生姜（切）三两 人参三两 甘草（炙）三两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【加减法】

若胸中烦而不呕者，去半夏、人参，加枳实一枚；若渴，去半夏，加人参合前成四两半、枳实根四两；若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两；若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两；若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两；若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝三两，温覆微汗愈；若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升、干姜二两。

【适应证】

（一）少阳病，口苦，咽干，目眩，胸胁苦满，心烦喜呕，默默不欲饮食，耳聋目赤，脉弦，舌苔白滑。

（二）妇人伤寒，热入血室，经水适断，寒热如疟，或有谵语，脉弦，苔白滑。

（三）伤寒头汗出，微恶寒，手足冷，心下满不欲食，大便硬的阳微结证。

【原文】

第37条、96条、97条、98条、99条、100条、101条、103条、144条、148条、149条、229条、230条、231条、266条、379条、394条。

【方义】

柴胡、黄芩清解少阳经腑之邪热，又能疏利肝胆气机，为和解少阳表里之主药；半夏、生姜和胃降逆止呕，能升能降，兼助柴胡透达经中

之邪；人参、甘草、大枣益气调中，扶正祛邪，以杜内传太阴之路。本方寒热并用，攻补兼施，辛升、苦降、甘调合于一方之中，虽治在肝胆，又旁顾脾胃；既清解邪热，又培补正气，而使三焦疏达，脾胃调和，内外宣通，枢机畅利，则半表半里之邪解。

【选注】

程应旆：“方中以柴胡疏木，使半表之邪得从外宣；黄芩清火，使半里之邪得从内彻；半夏豁痰饮，降里气之逆；人参补内虚，助生发之气；甘草佐柴芩，调和内外；姜枣佐参夏，通达营卫。相须相济，使邪不至内向而外解也。”

《医宗金鉴》：“邪传太阳、阳明，曰汗、曰吐、曰下；邪传少阳，唯宜和解，汗吐下三法皆在所禁，以其邪在半表半里，而再于躯壳之内界。在半表者，是客邪为病也；在半里者，是主气受病也。邪正在两界之间，各无进退而相持，故立和解一法。既以柴胡解少阳在经之表寒，黄芩解少阳在腑之里热，犹恐在里之太阴，正气一虚，在经之少阳邪气乘之，故以姜、枣、人参和中而预壮里气，使里不受邪而和，还表以作解也。”

【按语】

本方是和解少阳邪气的主方。少阳病有三禁，即禁汗、禁吐、禁下。此方能利少阳之枢机，而不通过汗、吐、下的手段，达到祛邪之目的，故称之为和解法。

本方的作用在于柴胡，故必须重用。《时方妙用》说：“方中柴胡一味，少用四钱，多用八钱。”认为柴胡的剂量以大于人参、甘草一倍以上为宜。《神农本草经》列柴胡为上品，性味苦平，微寒，无毒，主治肠胃中结气，饮食积聚，寒热邪气。现代药理学证明，柴胡的毒性很小，且有良好的解热和抗病原体的作用。因此，运用本方解热时，不必过于拘泥后世的“升阳劫阴”之说。由此看来，审证论治，遣方选药固然重要，而药物剂量的比例也不得忽视。

本方是针对少阳病主证而设，但病及少阳，病情往往复杂多变，所以运用本方要掌握两个原则：其一、首先要抓住柴胡汤的主证、主脉，如寒热往来的热型，胸胁苦满的病位，口苦、喜呕胆热的证情，脉弦、苍白的舌脉特征等。见到一、二个主证，便可用本方治疗，不必一一皆见。其二、本方的或然之证较多，因此，在辨明主证主脉的基础上，又要随证加减而应变。

【方歌】

小柴胡汤解少阳，胸满胁痛呕吐详；
口苦咽干目眩是，柴芩参草枣半姜。

【医案选录】

李某，女，38岁。长期呕吐，兼见低烧，服药已百余剂不效。脉弦而舌苔白滑。时有进修生陈君在侧，问曰：此何证也？余曰：呕而发热者，小柴胡汤主之。果服三剂而呕止热退。

（刘渡舟医案）

二、大柴胡汤

【药物组成】

柴胡半斤 黄芩三两 芍药三两 半夏（洗）半升 生姜（切）五两 枳实（炙）五枚 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，温服一升，日三服。（一方加大黄二两，若不加，恐不为大柴胡汤。）

【适应证】

（一）少阳病热结在里，往来寒热，胸胁苦满，口苦，郁郁微烦，呕不止，心下急，或痛或胀不可忍耐，大便秘结，舌苔黄腻，脉弦滑有力。

（二）发热汗出，心下痞硬，呕吐下利，里急后重，舌苔黄燥，脉弦滑。

【原文】

第103条、136条、165条。

【方义】

本方是小柴胡汤去人参、甘草，加大黄、枳实、芍药而成。方中柴胡、黄芩和解少阳之邪；大黄、枳实泻阳明之实；芍药于土中伐木，可敛阴和营，缓解腹中急痛；重用生姜，配半夏能止呕而又制大黄之迅下，配以大枣能补脾生津，调和营卫。八药相合，共为和解少阳兼泻阳明之剂。

【选注】

《医宗金鉴》：“柴胡证在，又复有里，故立少阳两解之法。以小柴胡汤加枳实、芍药者，解其外以和其内也。去参草者，以里不虚也。少加大黄，所以泻结热也。倍生姜者，因呕不止也。”

尤在泾：“大柴胡有柴胡、生姜、半夏之辛而走表，黄芩、芍药、

枳实、大黄之苦而入里，乃表里并治之剂。”

【按语】

许叔微说：“大柴胡汤，一方无大黄，一方有大黄。此方用大黄者，以大黄有荡涤蕴热之功，为伤寒中要药。”王叔和云：“若不用大黄，恐不名大柴胡汤。且经文明言下之则愈，若无大黄，将何以下心下之急乎？”应从许氏之说为是。

本方虽为少阳阳明并病而设，但因少阳之邪未全入里，故大黄只用二两，且无芒硝，同时尚有生姜、大枣以顾护脾胃。由此可见，本方重在和解少阳，而通下阳明为辅。《医宗金鉴》云：“斯方也，柴胡得生姜之倍，解半表之功捷；枳实得大黄之少，攻半里之效徐。虽云下之，亦下中之和也。”深得本方之旨。

本方在临床上应用为广，它不仅可以治疗多种急性胆道疾患，而且，凡是属于胆胃热实，气机受阻，疏泄不利，病位偏于两侧的急性疼痛，往往可获得满意的疗效。

柯韵伯云：大柴胡汤无加减，此说不免过于偏颇。实际使用本方时，常可依据证情，随证加减化裁。如挟湿热者，可酌加茵陈、山栀、茯苓；气郁甚者，酌加香附、郁金、木香；痛甚者，酌加元胡、川楝子；呕吐甚者，酌加竹茹、左金丸；有胆结石者，加金钱草、海金沙等。

【方歌】

大柴胡汤大黄枳，柴芩姜夏芍枣宜；
少明合病气火郁，呕吐口苦心下急。

【医案选录】

李某，女，54岁。右胁疼痛，掣及胃脘，不可忍耐，唯注射“杜冷丁”方可控制不疼。视其人体肥，面颊绯红，舌质红绛，舌根苔黄腻，脉沉弦滑有力。问其大便已四日未解，口苦时呕，不能饮食。西医有诊为胆囊炎，有诊为胆结石。余认为症见胁痛而大便不通，口苦而呕，舌苔黄腻，脉来弦滑，乃肝胃气火交郁，气血阻塞不通，不通则痛。治宜两解肝胃，泄热导滞。

处方：柴胡18克，黄芩9克，半夏9克，生姜12克，白芍9克，郁金9克，大黄9克，枳实9克，陈皮12克，生牡蛎12克。煎汤，分三次服。

一服，疼痛减轻得睡；二服，大便解下一次。从此，胁痛与呕泄俱

解，转用调理肝胃药而安。

（刘渡舟医案）

三、柴胡加芒硝汤

【药物组成】

柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参一两 甘草（炙）一两 生姜（切）一两 半夏二十铢（本云五枚洗） 大枣（擘）四枚 芒硝二两

【煎服法】

上八味，以水四升，煮取三升，去滓，内芒硝，更煮微沸，分温再服。不解更作。

【适应证】

（一）小柴胡汤证，大便燥结，傍晚发潮热者。

（二）已用泻下之药，胃津已伤，胃气不和，而少阳证未见者。

【原文】

第104条。

【方义】

本方即小柴胡汤加芒硝而成。以小柴胡汤和解少阳之邪，加芒硝软坚润燥和胃。本方有和解少阳与调和胃燥的作用，为少阳阳明兼治之剂。

【选注】

章虚谷：“按此方以小柴胡汤三分之一，而重加芒硝者，因其少阳之证误用丸药下之，余热留于阳明而发潮热，故仍用小柴胡和解少阳，而加芒硝咸寒润下，以清阳明之热，不取苦重之药峻攻也。”

柯韵伯：“不加大黄者，以地道原通；不用大柴胡者，以中气已虚也。”

【按语】

仲景治少阳有三禁，为理法之常。此方用下，则为理法之变。对于少阳兼里实者，根据其程度的轻重缓急，设有大柴胡汤和柴胡加芒硝

汤，然皆以柴胡为主，可见慎之至也。

【方歌】

小柴加硝两解方，芒硝后煎入药良；
日晡潮热胸胁满，调和胃胆利少阳。

四、柴胡桂枝汤

【药物组成】

柴胡四两 桂枝（去皮）一两半 黄芩一两半 人参一两半 甘草（炙）一两 半夏（洗）二合半 芍药一两半 大枣（擘）六枚 生姜（切）一两半

【煎服法】

上九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云人参汤，作如桂枝法，加半夏、柴胡、黄芩，复如柴胡法。今用人参作半剂）

【适应证】

发热微恶风寒，头痛或眩晕，四肢关节烦疼，微呕，心下支结，脉浮弦，舌苔薄白。

【原文】

第146条。

【方义】

本方为小柴胡汤与桂枝汤合方而成。以小柴胡汤和解少阳，以桂枝汤发表解肌。因太、少之证俱微，故各取原量之半，为内和少阳，外解太阳之法。

【选注】

《医宗金鉴》：“伤寒六七日，发热微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结者，是太阳之邪传少阳也。故取桂枝之半，以散太阳未尽之邪；取柴胡之半，以散少阳呕结之病。而不名桂枝柴胡汤者，以太阳外证虽未去，而病机已见于少阳里也。故以柴胡冠桂枝之上，意在解少阳为主，而散太阳为兼也。”

柯韵伯：“柴桂二汤，皆调和表里之证。桂枝汤重解表而微兼清里，柴胡汤重和里而微兼散表。此伤寒六七日，正寒热当退之时，尚见发热恶寒诸表症，更兼心下支结诸里症，表里不解，法当双解之。然恶寒微，则发热亦微可知；支节烦疼，则一身骨节不痛可知，故谓之支结。表症虽不去而已轻，里症虽已见而未甚。此太阳、少阳并病之轻

者，故取桂枝之半，以解太阳未尽之邪，取柴胡之半，以解少阳之微结。凡口不渴，身有微热者，当去人参。此以六七日来，邪虽不解，而正气已虚，故用人参以和之也。外证虽在，而病机已见于里，故方以柴胡冠桂枝之前，为双解两阳之轻剂。”

【按语】

本方后有“本云人参汤……”二十九字，疑是衍文。

尤在泾认为本方能外解表邪，内除支结，乃七表三里之法。但许多注家却持有不同的看法，如《医宗金鉴》云：本方不名桂枝柴胡汤者，而以柴胡冠桂枝之上，意在解少阳为主，散太阳为兼也。

本方除能治疗太少并病以外，根据临床经验，还可治疗慢性肝炎续发的肝脾肿大，如减去人参、大枣，酌加鳖甲、牡蛎、红花、茜草、土鳖虫等软坚消痞、活血通络之品，多能收效。此方又治神经官能症的周身气窜作痛，以及风痹挟有肝气等证，其效果亦令人满意。

【方歌】

柴胡桂枝两方合，善治太少两经病；心下支结关节痛，初期肝硬亦能和。

【医案选录】

刘某，女，21岁。产后三天突发寒战，继之高烧，体温最高达41.2℃，汗多，头昏，两侧太阳穴痛，目胀，全身疼痛不适，口苦而干，欲呕，大便整日未行，小便尚畅，脉浮数，舌浅红，苔白微腻。诊为产后外感风寒，太少两阳合病之候。

处方：桂枝二钱，白芍二钱，甘草二钱，生姜二钱，大枣四枚，柴胡二钱，黄芩二钱，半夏一钱半，沙参三钱，葛根三钱，一次服。

服药后次日，体温恢复正常，诸症减轻，不思饮食，仍宗原法减葛根，加丹参二钱、花粉三钱、知母三钱、麦冬三钱，一次服。三诊时，诸症悉除。翌日痊愈出院。

（摘自《广东医学·祖国医学版》1963，1）

五、柴胡桂枝干姜汤

【药物组成】

柴胡半斤 桂枝（去皮）三两 干姜二两 栝蒌根四两 黄芩三两 牡蛎（熬）二两 甘草（炙）二两

【煎服法】

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。初服微烦，复服，汗出便愈。

【适应证】

（一）往来寒热，胸胁满微结，心烦，渴而不呕，但头汗出，小便利，大便溏薄，脉弦而缓，舌淡苔白。

（二）《金匱》治疟，寒多微有热，或但寒不热，服一剂如神。

【原文】

第147条。

【方义】

本方即小柴胡汤减半夏、人参、生姜、大枣，加桂枝、干姜、牡蛎、栝蒌根而成。柴胡配黄芩，以和解少阳之邪；桂枝、干姜、炙甘草补脾散寒，温通阳气；栝蒌根生津止渴，配牡蛎以软坚开结。不呕，故去半夏；因气化受阻，故去参枣之滞，而加桂枝、干姜之行。此方既解少阳之邪，又能温寒通阳而行气化。

【选注】

《医宗金鉴》：“少阳表里未解，故以柴胡桂枝合剂而主之，即小柴胡汤之变法也。去人参者，因其正气不虚；减半夏者，以其不呕，恐助燥也。加栝蒌根，以其能止渴兼生津液也；倍柴胡、加桂枝，以主少阳之表；加牡蛎，以软少阳之结。干姜佐桂枝，以散往来之寒；黄芩佐柴胡，以除往来之热，且可制干姜不益心烦也。诸药寒温不一，必需甘草以和之。初服微烦，药力未及。复服汗出即愈者，可知此证非汗出不解也。”

【按语】

柴胡桂枝干姜汤证，可续发于太阳病。如伤寒五六日，已发汗不愈，而又用攻下，以致邪陷少阳，气郁不舒，故胸胁满微结；胆火上炎而灼津，故心烦、口渴；热邪不得宣泄而上蒸，故但头汗出；正邪纷争，故往来寒热；无关于胃，故不呕；三焦气机阻滞，故小便不利；内伤脾寒，故见腹满或大便溏泻。此证为胆热而脾寒，故应清少阳之热，兼温太阴之寒，则柴胡桂枝干姜汤为宜。

本方为小柴胡汤加减而成。小柴胡汤有“胸中烦而不呕者，去半夏、人参，加栝蒌实一枚；若渴，去半夏，加人参合前成四两半、栝蒌根四两”的加减法。今见心烦、口渴而不呕，故减去人参、半夏，加栝蒌根以滋阴液而胜热。“若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎，”今胁下满微结，即为痞硬之征，故去大枣加牡蛎。“若心下悸、小便不利者，去黄芩加茯苓”，今虽小便不利，但心下不悸而见烦，说明是津少而有热，并非内有蓄水，故仍留黄芩以清热。因无水邪，故不加茯苓。以干姜易生姜，并加桂枝，取其辛温散结，温中散寒以行气津，故初服药可见微烦。再服，表里和、阳气通、津液行，因而“汗出便愈”。

【方歌】

柴胡桂姜痛胁背，大便不实尿欠利；
阳邪向阴气化衰，柴芩姜桂草粉蛎。

【医案选录】

刘某，男，54岁。患肝炎而腹胀作泻，不欲饮食，胁痛及背，服药无数，效果不显。某君请余为治。脉弦而缓，舌淡苔白，此乃肝病及脾，脾阳先衰之象。为疏柴胡桂枝干姜汤。处方：柴胡12克，黄芩4.5克，炙甘草9克，干姜9克，桂枝9克，花粉12克，牡蛎12克。凡四服而腹胀与泻俱止，饮食较前为多，精神亦有好转。后以肝脾共调，佐以健脾利湿之品，肝功化验日趋正常而愈。

（刘渡舟医案）

六、柴胡加龙骨牡蛎汤

【药物组成】

柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜（切） 铅丹 人参 桂枝（去皮） 茯苓各一两半 半夏（洗）二合半 大黄二两 牡蛎（熬）一两半 大枣（擘）六枚

【煎服法】

上十二味，以水八升，煮取四升，内大黄，切如碁子，更煮一两沸，去滓，温服一升。（本云柴胡汤，今加龙骨等。）

【适应证】

谵语烦躁，惊怖不安，胸胁苦满，二便不利，周身困重，难以转侧，舌苔黄腻，脉弦滑或弦数。

【原文】

第107条。

【方义】

本方系小柴胡汤去甘草，加桂枝、茯苓、大黄、龙骨、牡蛎、铅丹而成。小柴胡汤去甘草加桂枝，以转少阳之枢，兼行太阳之气，使内陷之邪得从外解；龙骨、牡蛎、铅丹重镇肝胆，镇敛精神以治烦惊；大黄泄热和胃而止谵语；茯苓宁神又利小便。共为和解少阳，泄热和胃，重镇安神之剂。

【选注】

尤在泾：“伤寒下后，其邪有并归一处者，如结胸下利诸候是也，有散漫一身者，如此条所云诸证是也。胸满者，邪痹于上；小便不利者，邪痹于下；烦惊者，邪动于心；谵语者，邪结于胃，此病之在里者也。一身尽重、不可转侧者，筋脉骨肉并受其邪，此病之在表者也。夫合表里上下而为病者，必兼阴阳合散以为治。方用柴胡、桂枝，以解其外而除身重；龙、蛎、铅丹以镇其内而止烦惊；大黄以和胃气止谵语；茯苓以泄膀胱利小便；人参、姜、枣益气养营卫，以为驱除邪气之本也。如是表里虚实，泛应曲当，而错杂之邪，庶几尽解耳。”

《医宗金鉴》：“是证也，为阴阳错杂之邪。是方也，亦攻补错杂之药。柴桂解未尽之表邪，大黄攻已陷之里热，人参、姜、枣补虚而和胃，茯苓、半夏利水而降逆，龙骨、牡蛎、铅丹之涩重，镇惊收心而安神明。斯为以错杂之药而治错杂之病也。”

【按语】

本方所主，乃是伤寒误下之后，邪热乘虚内扰，弥漫全身，表里上下俱病，虚实互见的证候。证情虽较复杂，但主要病变在于少阳，为肝胆失调，气火交郁，心神被扰，不得潜藏所致。故本方仍在小柴胡汤上加减，以开郁泄热，镇惊安神，表里兼治为其宗旨。

本方现常用于治疗精神分裂症、癫痫、小儿舞蹈症，以及小儿内伤食滞、外感风寒，痰热搏结所致之惊痫、食厥、热厥等证。凡病机属于肝胆者，均有一定效果。运用本方时，可随证加或化裁。如肝火偏盛者，加龙胆草、夏枯草、山栀；病及血分者，加桃仁、丹皮；顽痰凝结不开者，加郁金、胆星、明矾。此方铅丹有毒，用时剂量宜小不宜大，宜暂不宜久，并以纱布包裹扎紧入煎。

【方歌】

柴加龙牡桂丹铅，大黄茯苓记要诀；
减去甘草铅要裹，胸满烦惊小便难。

【医案选录】

尹某，男，34岁。胸胁发满，夜睡呓语不休，且乱梦纷纭，时发惊怖，精神不安，自汗出，大便不爽。既往有癫痫病史，此病得于惊吓之余。视其人神情呆滞，面色发青，舌红而苔白黄相兼，脉沉弦。辨为肝胆气郁，兼阳明腑热，而心神被扰，不得潜敛之证。治宜疏肝泻胃，镇惊安神。

处方：柴胡12克，黄芩9克，半夏9克，生姜9克，龙骨15克，牡蛎15克，大黄6克（后下），铅丹4.5克（布包），茯神9克，桂枝4.5克，大枣6枚。

服一剂，大便通畅，胸胁满与呓语皆除，精神安定，不复梦扰，唯欲吐不吐，胃中似嘈不适，上方加竹茹、陈皮，服之而愈。

（刘渡舟医案）

七、四逆散

【药物组成】

甘草（炙） 枳实（破、水渍、炙干） 柴胡 芍药

【煎服法】

上四味，各十分，捣筛，白饮和服方寸匕，日三服。

【加减法】

咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利；悸者，加桂枝五分；小便不利者，加茯苓五分；腹中痛者，加附子一枚，炮令坼；泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，煮取三升，去滓，以散三方寸匕，内汤中，煮取一升半，分温再服。

【适应证】

（一）急性热病中，若因阳气内郁，而见手足不温，胸胁苦满，或心下痞塞，脉弦，舌苔白滑者，可用此方治疗。

（二）下利，脘腹胀满或疼痛，厌食，里急后重，下利不畅，四肢不温，而脉弦者。

（三）妇人月经不调，胸胁引痛，少腹胀痛，脉弦，或微有寒热。

【原文】

第318条。

【方义】

方中柴胡疏利肝胆，透达阳郁；枳实降胃导滞，行气散结。二者一升一降，使枢机运转，阳气外达。芍药平肝和阴，土中泻木；甘草补中益气，与芍药相配，又能调和肝脾，而治腹痛。四药合而成方，使气机条达，阳郁得伸，则肢厥可温，肝脾调和，则胁腹满痛与泄利下重自除。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡少阴四逆，虽属阴盛不能外温，然亦有阳为阴郁不得宣达，而令四肢逆冷者，故有或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛、泄利下重诸证也。今但四逆而无诸寒热证，是既无可温之寒，又无可下之热，唯宜舒畅其阳，故用四逆散主之。”

张令韶：“凡少阴四逆，俱属阳气虚寒，然亦有阳气内郁，不得外达而四逆者，又宜四逆散主之。枳实形圆臭香，胃家之宣品也，所以宣通胃络；芍药疏泄经络之血脉，甘草调中，柴胡启发阳气而外达，阳气通，而四肢温矣。”

【按语】

本证之四逆，系阳气内郁，不能外达四肢所致。往往伴见肝郁气滞、肝脾不和等证候。而且本证的厥冷程度并不严重，仅表现手足不温。正如李士材所云：“此证虽云四逆，必不甚冷，或指头微温，或脉不沉微。”对比之下，如阳虚阴盛的寒厥，或热深厥深的热厥，其厥冷程度要严重得多。除此之外，寒厥还伴有恶寒蜷卧，精神萎靡，下利清谷，脉微细等证。热厥必有恶热烦躁，胸腹灼热，口渴引饮，小便短赤，大便秘结，舌红脉沉数等证。三证应具体分析而不得混为一谈。

本方功在调和肝脾，后世疏肝诸方，如柴胡疏肝散、逍遥散等，皆从本方发展而成。本方治疗急慢性肝炎、早期肝硬化、胆道疾患、胃肠神经症、胸膜炎、肋间神经痛、痢疾、疝气、妇人月经不调、男子阳痿等证，均有一定的疗效。

【方歌】

柴芍枳草四逆散，肝郁气结肢不暖；
脉沉而弦胸胁满，随证治疗须加减。

【医案选录】

一青年，体甚壮，其妻从乡间来，风尘仆仆，一路劳乏，入夜而睡，未行女妻之事，青年强之，则拒之甚力。由此，青年顿然阳痿，求医又多服补肾之药，则终不能起矣。切其脉弦，按之有力。此乃肝肾气郁，亦实证中之羸候也。为疏四逆散原方，加知母6克、黄柏6克，凡三剂而愈。

（刘渡舟医案）

芍药当归汤类概述

芍药当归汤类，包括芍药甘草汤、芍药甘草附子汤、当归四逆汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤四方。芍药、当归均为血分药，而有养阴补血的作用，故芍药甘草汤治阴血虚的脚挛急；芍药甘草附子汤则治阴阳两虚的身恶寒，可见芍药剂而有养阴血的功效。当归四逆汤则治血虚受寒的脉细欲绝，手足厥冷之证；若加吴茱萸生姜，则治厥阴内有久寒的小腹疼痛，或呕吐涎沫等证，反映了当归剂有养血温经之美。

一、芍药甘草汤

【药物组成】

白芍药 甘草（炙）各四两

【煎服法】

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

【适应证】

治阴血虚于下的脚挛急。

【原文】

第29条。

【方义】

芍药酸苦，和血养筋；甘草和以缓急。二药合用，酸甘化阴，使阴液得复，筋脉得养，则脚挛急自伸。

【选注】

成无己：“芍药白补而赤泻，白收而赤散也。酸以收之，甘以缓

之，酸甘相合，用补阴血。”

柯韵伯：“以芍药之酸收，协甘草之平降，位同力均，则直走阴分，故脚挛可愈。”又云：“盖脾主四肢，胃主津液，阳盛阴虚，脾不能为胃行津液以灌四旁，故足挛急。用甘草以生阳明之津，芍药以和太阴之液，其脚即伸。此亦用阴和阳法也。”

【按语】

肝藏血、主筋，肝血不足则筋脉失养，出现挛急疼痛之证。本方具有柔肝舒筋、缓急止痛、敛津液、养阴血等作用。程钟龄说本方“止腹痛如神。脉迟为寒，加干姜；脉洪为热，加黄连。”已被广大医家所公认。近年来，还有人用本方治疗肠粘连的腹痛不止，加上活血祛瘀之品，亦可取得疗效。

芍药分赤、白两种，根据中医传统的经验，疼痛拒按者属实，一般用赤芍，疼痛喜按者属虚，一般用白芍。

现代药理学证实：本方对横纹肌、平滑肌的挛急，不管是中枢性或末梢性的，均有镇静解痉作用。不仅对表在性的躯体和四肢的平滑肌，而且对深在性的平滑肌性脏器，如胃、肠、胆囊、输卵管、子宫、膀胱、尿道、血管等，也能缓解其挛急，制止其疼痛的功效。

【方歌】

芍药甘草两药投，筋挛拘急足趾抽；

苦甘化阴利血脉，滋阴柔肝效立瘳。

【医案选录】

李某，男，25岁。右腿鼠溪部生一肿物，形如鸡卵，表面不红，用针管抽不出内容物。右腿拘紧，伸而不能直，强伸则剧烈疼痛，足跟不能着地。每到夜晚，小腿经常抽筋，痛苦不堪。脉弦细而数，舌红而少苔。脉证合参，可知本证属阴血不濡、筋脉失养，挛而收引，故筋聚而成包块，腿难伸直，拘急转筋作痛。为疏：白芍24克，炙甘草12克，嘱服三剂，以观后效。仅一剂而筋不抽痛，夜得安睡。进二剂，则鼠溪包块消退。服第三剂，足跟即能着地。又服一剂，而诸证皆除。

（刘渡舟医案）

二、芍药甘草附子汤

【药物组成】

芍药 甘草（炙）各三两 附子（炮，去皮、破八片）一枚

【煎服法】

上三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分温三服。（疑非仲景方）

【适应证】

阴阳皆虚而恶寒者。

【原文】

第68条。

【方义】

本方用附子以补阳虚，芍药以和阴血，炙甘草于附子、芍药之间而两补阴阳之虚。

【选注】

陈修园：“方中芍药、甘草苦甘以补阴，附子、甘草辛甘以补阳。附子性猛，得甘草而缓；芍药性寒，得附子而和……此阴阳双补之良方。”

丹波元简：“此方与芍药甘草汤中加附子，于四逆汤中去干姜代芍药，阴阳双救之义自可知也。”

【按语】

“发汗病不解，反恶寒者，虚故也。”这是误发虚人之汗，造成正虚不固的后果。发汗后的恶寒，有表不解者，有正虚者。如汗后脉浮而恶寒，则为表不解，可考虑用桂枝汤；若发汗后，其脉由浮变为沉迟，方为阴阳两虚之候，则用芍药甘草附子汤调补阴阳，其病自愈。

【方歌】

芍药甘草附子汤，汗后阴阳两俱伤；
恶寒不热应温补，芍甘和阴附助阳。

【医案选录】

范某，男，60岁，农民，华容人。因冬月担水不慎摔倒，扭伤腰部，当时疼痛剧烈，行走不便，自觉右侧腰部有冷感。查局部无明显肿胀，但第三、四腰椎右侧有明显压痛，活动时右腰部痛甚，脉舌无变化。以芍药甘草附子汤加乳香10克、没药10克，水煎服。并以生姜、葱白共捣热敷患处，服完四剂，痛止。

（摘《湖南中医学院学报》1980，1：14）

三、当归四逆汤

【药物组成】

当归三两 桂枝（去皮）三两 芍药三两 细辛三两 甘草（炙）二两 通草二两 大枣（擘）二十五枚（一法十二枚）

【煎服法】

上七味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

脉细欲绝，手足厥冷。

【原文】

第351条。

【方义】

本方用桂枝汤滋阴和阳，并疏解风寒；另加当归补血通脉，通草以除邪滞，细辛散寒止痛，多用大枣以监细辛之散，又滋血脉之虚。七药和合，共成养血滋营，温经散寒之剂。

【选注】

成无己：“手足厥寒者，阳气外虚，不温四末。脉细欲绝者，阴血内弱，脉行不利。与当归四逆汤，助阳生阴也。”

尤在泾：“手足厥寒，脉微欲绝者，阳之虚也，宜四逆辈。脉细欲绝者，血虚不能温于四末，并不能荣于脉中也。夫脉为血之府，而阳为阴之先，故欲续其脉，必益其血；欲益其血，必温其经。方用当归、芍药之润以滋之，甘草、大枣之甘以养之，桂枝、细辛之温以行之，而尤藉通草之入经通脉，以续其绝而止其厥。”

【按语】

本方主治手足厥寒，脉细欲绝之证。夫细属血虚，微为阳虚，厥虽略同，而病机则异。本方用桂、芍、草、枣加当归、细辛、通草为补血散寒之计。肝藏血，养血即所以补肝，故本方对厥阴血虚受寒，少腹拘

急疼痛和妇人血寒痛经，以及肝经风寒巅头痛等证都有一定的疗效。

本方可用于血虚之痹证。根据日本《汉方医学》报道，对冻疮无论初期未溃，或久溃不愈，内服外敷都有疗效。近年来还报道治疗早期“雷诺氏病”，也值得推荐。

【方歌】

当归四逆治厥寒，脉细欲绝病非凡；

归芍桂甘枣通细，补血散寒治在肝。

【医案选录】

钱某，男，38岁，1961年12月20日就诊。自诉1960年冬发病，就诊时面部青紫斑斑，鼻尖、耳轮几乎呈青黑色，两手青紫及腕际，指尖更甚，有麻冷感，拇指亦紫，体温35℃，脉象细微，遇火烤则转红。束臂试验阴性，血小板计数正常。诊断为早期雷诺氏病。处方：

桂枝三钱，当归三钱，赤芍二钱，北细辛八分，木通二钱，吴茱萸二钱，艾叶一钱五分，桃仁三钱，红花一钱，炙草八分，红枣五枚，生姜三片。

服三十余剂而愈。至1963年未复发。

（摘《江苏中医，1965，6：15》）

四、当归四逆加吴茱萸生姜汤

【药物组成】

当归三两 芍药三两 甘草（炙）二两 通草二两 桂枝（去皮）三两 细辛三两 生姜（切）半斤 吴茱萸二升 大枣（擘）二十五枚

【煎服法】

上九味，以水六升，清酒六升和，煮取五升，去滓，温分五服。
（一方酒、水各四升）

【适应证】

当归四逆汤证，兼见厥阴肝经受寒的腹痛、呕吐等证。

【原文】

第352条。

【方义】

当归四逆汤治血虚寒凝，温经通脉；再加吴茱萸、生姜辛苦而降，温中散寒，以暖肝胃，降逆止呕，而治小腹疼痛。

【选注】

尤在泾：“若其人内有久寒者，必加吴茱萸、生姜之辛以散之，而尤藉清酒之濡经浹脉，以散其久伏之寒也。”

【按语】

内有久寒，是说内有陈寒积冷，不只是在经，而已深入于脏，故有胃脘冷痛、呕吐之症。当归四逆加吴茱萸、生姜，温经以散脏寒。此方不用干姜、附子者，因阴血虚微，刚药恐反劫阴故也。

【方歌】

当归四逆加萸姜，清酒烹来效始彰；
内有久寒厥阴是，药分五次缓服康。

【医案选录】

白某，女，36岁。经期参加劳动，汗出衣湿，入厕小解时，风吹下体，顿觉不适，返家后而少腹拘急疼痛难忍。切其脉弦细，视其舌则淡。辨为血虚受寒，邪客肝经之证。

为疏：当归12克，白芍12克，桂枝10克，炙甘草6克，通草6克，细辛6克，大枣15枚。服三剂而腹痛瘳。

（刘渡舟医案）

干姜汤类概述

干姜汤类共有三方，即干姜附子汤、干姜黄芩黄连人参汤和理中汤。干姜附子汤治阳虚阴盛的昼日烦躁证。干姜黄芩黄连人参汤则治饮食入口即吐的寒热阻格证；理中汤则治脾阳不运，寒湿内生的呕吐下利等证。

理中汤又名人参汤，应列入人参汤类，因人参难于类聚，故列于干姜汤下，而一并论述。

一、干姜附子汤

【药物组成】

干姜一两 附子（生用、去皮、切八片）一枚

【煎服法】

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

【适应证】

昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕不渴，身无大热，脉沉微。

【原文】

第61条。

【方义】

本方系四逆汤去甘草而成。附子、干姜大辛大热，破阴回阳。因病势急迫，故不用甘草之缓恋，以利于姜附之回阳。浓煎一次顿服，俾药力集中，收效更速。

【选注】

柯韵伯：“茯苓四逆固阴以收阳，干姜附子固阳以配阴，二方皆从四逆加減，而有救阳救阴之异。茯苓四逆比四逆为缓，固里宜缓也。姜附者，阳中之阳也。用生附而去甘草，则势力更猛，比四逆为峻，回阳当急也。一去甘草，一加茯苓，而缓急自别。加減之妙，见用方之神乎。”

喻昌：“用附子、干姜以胜阴复阳者，取飞骑突入重围，搴旗树帜，使既散之阳望而争趋，顷之复全耳。不知此义者，加增药味，和合此汤，反牵制其雄入之势，必至迂缓无功。”

【按语】

烦躁一证，统而言之，有阴阳之别。烦躁属阳热实证者，人所易知，而属里虚之烦躁者，最易被人忽略。本方所主之烦躁，为下后复汗，阳衰阴盛，而阳为阴格，欲争无力之象。虚阳得其时始争，故昼日烦躁；失时则力弱不能争，故夜而安静。阳不胜阴，气血皆寒，而反身有微热，阳亡于外而欲脱软，故急投本方，追回散失之阳气。

本方与茯苓四逆汤同为治阳虚烦躁之方，但两方的作用有别。彼为汗下后，阴阳两虚，故用以回阳救阴；此为汗下后，阳虚阴盛，故用以扶阳抑阴。

【方歌】

干姜附子治少阴，阳虚烦躁夜则宁；
不呕不渴无表证，身无大热脉微沉。

【医案选录】

李东垣治一人，恶热目赤，烦渴引饮，脉七八至，按之则散，此无根之火也。与姜附加人参服之愈。

（摘《名医类案》）

二、干姜黄芩黄连人参汤

【药物组成】

干姜 黄芩 黄连 人参各三两

【煎服法】

上四味，以水六升，煮取二升，去滓，分温再服。

【适应证】

治“寒格”误用吐下，饮食入口即吐。

【原文】

第359条。

【方义】

干姜辛开，以散气结；芩连苦寒，以降胃逆；并以人参补中益气，以恢复吐后之虚。

【选注】

章虚谷：“病者本自中寒，而又伤外感，则当温中解表，庸下之医复吐下之，其寒气格拒，更逆而吐下。若食入口即吐者，阻在上脘，阴阳不相交通，故以干姜、芩、连寒热并用，通其阴阳，辛苦开泄以降浊，人参补正而升清，则中宫和而吐利可止矣。”

柯韵伯：“妄吐下后，食入口即吐，是为食格，此肺气胃气受伤之别也。入口即吐，不使少留，乃火炎上之象，故苦寒倍于辛热。不名泻心者，以泻心汤专为痞硬之洁耳。要知寒热相结于心下，而成痞硬，寒热相阻于心下，而成格逆，源同而流异也。”

【按语】

章、柯二氏之注均很精当。柯氏指出本方所治系寒热格拒证，与寒热互结致痞的泻心汤证源同而流异，立论更为精辟。本方与半夏、生姜、甘草等泻心汤同取辛开苦降甘调法，同治脾胃升降失常，寒热错杂之证，但二者的主证有所不同。泻心汤证以痞为主，呕、利为次；本证

以呕为主，未及于心下痞，说明虽见寒热相阻，逆而作吐，但还未达到气痞的程度。因证候较轻，故制方用药仅用泻心之半而已。

本汤证的辨证着眼点在于“食入即吐”。王冰曰：“食入即吐，是有火也。”陆渊雷云：“凡朝食暮吐者，责其胃寒；食入即吐者，责其胃热。”陈修园亦以为此证乃火郁作吐，若以生姜代干姜更有妙义。

【方歌】

干姜芩连与人参，辛开苦降法超群；
四物平行各三两，诸凡格拒此方珍。

【医案选录】

林某，五十岁，患胃病已久。近来时常呕吐，胸间痞闷，一见食物便产生恶心感。有时勉强进食少许，有时食下即呕，口微燥，大便溏泄，一日两三次，脉虚数。我与干姜黄芩黄连人参汤。处方：横纹潞五钱，北干姜三钱，黄芩二钱，黄连一钱五分，水煎，煎后待稍温时分四次服。服一剂后，呕恶、泄泻均愈。又嘱病者购生姜、红枣各一斤，切碎和捣，于每日三餐蒸饭时，量取一酒盏置米上蒸熟，饭后服食。服一疗程后（即尽两斤姜枣），胃病几瘥大半，食欲大振。后病，又照法服用一疗程，胃病因而获愈。

（摘《伤寒论汇要分析》）

三、理中丸（汤）

【药物组成】

人参 干姜 甘草（炙） 白术各三两

【煎服法】

上四味，捣筛，蜜和为丸，如鸡子黄许大。以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三四、夜二服。腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法：以四物依两数切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。服汤后，如食顷，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

【加减法】

若脐上筑者，肾气动也，去术加桂四两；吐多者，去术加生姜三两；下多者还用术；悸者，加茯苓二两；渴欲得水者，加术足前成四两半；寒者，加干姜足前成四两半；腹满者，去术加附子一枚。

【适应证】

腹胀满，时腹自痛，喜温喜按，呕吐，下利，自利不渴，饮食不下，或多涎唾，舌质淡嫩，苔白，脉沉缓迟弱。

【原文】

第159条、386条、396条。

【方义】

人参、炙甘草补中益气，干姜温中去寒，白术健脾燥湿，务使脾阳健运，中阳振奋，寒湿一除，则诸证自愈。

【选注】

柯韵伯：“太阴病，以吐利腹满痛为提纲，是遍及三焦矣。然吐虽属上，而由于腹满，利虽属下，而亦由于腹满，皆因中焦不治以致之也。其来有三：有因表虚而风寒自外入者，有因下虚而寒湿自下上者，有因饮食生冷而寒邪由中发者，总不出于虚寒。法当温补以扶胃脘之阳，一理中而满痛吐利诸症悉平矣。故用白术培脾土之虚，人参益中宫

之气，干姜散胃中之寒，甘草缓三焦之急也。且干姜得白术，能除满而止吐，人参得甘草，能疗痛而止利。或汤或丸，随机应变，此理中确为之主剂欤。”

【按语】

本方是温运脾阳的主方。所治腹满、腹痛，而有时轻时重，喜温喜按的特点。而且此证越泻则腹越满，不因泻下而减轻。所以，它和阳明腑实证的大便燥结、腹满不减、腹痛拒按等证而不相同。

本方有丸汤之分，若用蜜丸，适宜于慢性脾胃虚寒证。若用汤服，适用于寒邪直中太阴，病情较急，方能以求速效。

本方一名人参汤，《金匱要略》用以治疗胸痹虚证，症见：心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心，兼见四肢逆冷，少气倦怠，脉象沉迟等。

本方加减之法：如兼表证者，则加桂枝；脾肾虚寒的，则加附子；脾虚肠热久利不愈的，则加黄连；阴黄脾虚，小便不利，而脉沉迟者，则加茵陈。

【方歌】

理中白术与人参，干姜炙草四药亲；

脾阳虚衰寒湿甚，腹满吐利脉迟沉。

【医案选录】

黄某，女，35岁。患水肿病新瘥，面部仍有轻微浮肿，面色淡黄，唇色不荣。近日胃脘作痛，绵绵不休，口中干燥，大便三日未通，脉象沉涩，舌白而干。我拟理中汤一剂，方用：党参四钱，白术三钱，干姜二钱，炙草三钱。门人问：口燥便秘而用理中汤，岂不怕使燥结更甚吗？我说：此证乃脾虚中阳不振，运化失司，水津不布，津液不上输，故口燥舌干，不下行，故大便秘。是太阴里虚寒，而非阳明里实热证，从患者以往病史及当前面色、脉象可知。其痛绵绵不休，腹无硬结，不拒按，是虚痛，故用理中汤温中健脾，使脾阳振奋，津液得行，所以诸症状即可解除。

次日复诊，大便已通，口舌转润，胃脘痛随之而减，遂以六君子汤以善其后。

（摘自《伤寒论汇要分析》）

赤石脂汤类概述

赤石脂汤类共有二方。一名赤石脂禹余粮汤，是治疗下焦下利、下焦滑脱而不能固涩所致。一名桃花汤，是治疗少阴病下利便脓血，由于下焦不约，气病及血之所致。

总而言之，赤石脂类为温涩固脱之剂。两方皆治下利，皆有涩肠固下的作用，但对热湿相蕴的下利后重、口渴欲饮等证，则是绝对禁用。

一、赤石脂禹余粮汤

【药物组成】

赤石脂（碎）一斤 太一禹余粮（碎）一斤

【煎服法】

上二味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

【适应证】

治疗少阴病虚寒下利，日久不止，下焦滑脱，肾关失约之证。

【原文】

第159条。

【方义】

赤石脂甘温而涩，有填补下焦、涩肠固脱的作用；禹余粮能补脾涩肠。二药合用，为涩以固脱之法。

【选注】

柯韵伯：“夫大肠之不固，仍责在胃，关门之不闭，仍责在脾……石者，土之刚也，二石皆土之精气所结……实胃而涩肠。用以治下焦之

际，实以培中宫之本也。”

【按语】

本方所治之下利，是滑泄不禁，为下元不固，大肠滑脱所致。仲景立固涩一法而别开生面。

赤石脂、禹余粮均难溶于水，而奏治疗之功，可能与它的微量元素有关。若参照桃花汤服法，将二药研细末，煎其一半，调服药末一半，使药吸着肠壁，则效果更好。

本方治崩中、漏下、白带、脱肛，凡因脾虚下陷或肾虚不固等疾患，方中加入此药，以求其效。

【方歌】

赤石禹粮两药珍，大便滑脱利不禁；
理中不应宜此法，涩以固脱是指针。

【医案选录】

陈某，男，56岁。患者于十年前，因便秘努责，导致脱肛，劳累即坠，甚至脱出寸余，非送不入。继之并发痔疮，经常出血，多方治疗不愈。按脉虚细，舌淡，体形羸瘦，肤色苍白，精神委顿，腰膝无力，纳食呆滞，大便溏滑。证属气虚下陷，脾肾阳微。以赤石脂、禹余粮各五钱，菟丝子、炒白术各三钱，补骨脂二钱，炙甘草、升麻、炮干姜各一钱五分。服三剂后，直肠脱出能自缩入，粪便略调。继服三剂，肠脱未出肛口，大便正常，食欲增加。后随证略为损益，继服六剂，脱肛完全治愈。同时，如黑枣大的痔疮缩小为黄豆大。一年后复诊，见其肤色润泽，精神饱满，询知脱肛未复发。

（摘《浙江中医》1966，9）

二、桃花汤

【药物组成】

赤石脂一斤（一半全用，一半筛末） 干姜一两 粳米一升

【煎服法】

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温服七合，内赤石脂末方寸匕，日三服。若一服愈，余勿服。

【适应证】

泻下脓血，滑脱不禁，暗淡不鲜，腹痛绵绵，喜温喜按，口淡不渴，小便不利，神疲乏力，舌淡苔白，脉弱无力。

【原文】

第306、307条。

【方义】

赤石脂甘温而涩，有调中固脱之功；干姜辛热，守而不走，能温中止利；又益以粳米之甘，而充养胃气，以滋养化源。

【选注】

成无己：“涩可去脱，赤石脂之涩，以固肠胃；辛以散之，干姜之辛，以散里寒；粳米之甘，以补元气。”

【按语】

下焦下利，阳损及阴，而血脉损伤，遂致脓血夹杂而滑脱不禁。这与起病急暴、腹痛拒按、里急后重、口渴喜饮而小便短赤的湿热下利不能混为一谈。本方温中固脱，涩肠止利，若酌加参芪补虚之品亦无不可。

赤石脂一半用粉末冲服，意在令其附着肠道，以加强收敛而保护肠黏膜。

【方歌】

桃花石脂米干姜，少阴下利脓血方；
温固下焦和胃气，汤末搭配力方彰。

【医案选录】

程某，男，56岁。患肠伤寒住院治疗40余日，基本已愈。唯大便泻下脓血，血多而脓少，日行三四次，腹中时痛，屡治不效。其人面色素来不泽，手脚发凉，体疲食减，六脉弦缓，舌淡而胖大。此证为脾肾阳虚，寒伤血络，下焦失约，属少阴下利便脓血无疑，且因久利之后，不但大肠滑脱，而气血虚衰亦在所难免，治当温涩固脱保元。

赤石脂30克（一半煎汤、一半研末冲服），炮姜9克，粳米9克，人参9克，黄芪9克。

服三剂而血止，又服三剂，大便不泻而体力转佳。转方用归脾汤加减，巩固疗效而收功。

（摘《伤寒论通俗讲话》）

四逆汤类概述

四逆汤类计有九方。方方皆有附子，用治少阴病阳虚的寒化证。少阴寒证，若验之于脉，则脉沉而缓，或微细如丝，而按之无神。若验之于舌，则舌带糙米色，或如猪腰，或如淡墨，或白苔而润，或无苔而燥，或舌短不能伸。此证口淡而不渴，或渴不欲饮，或欲饮热汤，反映了少阴阳虚不能化生津液，治疗当用四逆汤扶阳以胜阴。然少阴寒盛之极，则有格阳之变，而见反常之象，往往使人难以辨认。如阴寒内盛，而反发热面赤，烦躁不安，其人欲揭去衣被，口渴欲饮冷水等证，此乃阴盛格阳之假热。若误认为真热，投以寒凉药物，则必加速其死。为此，少阴病当凭脉辨证，其方法不论脉之浮沉大小，但觉指下无力，而按之筋骨全无者，反映了内有伏阴，阳气不足之候，即不得冒进凉药，如误用则亡阳必死。

凡阴盛格阳之证，如见身热、烦躁、面赤等象，只要细心察其脉证，其中必有真伪之辨，贵在细心而已。治疗之法，急以通脉四逆汤，倍用人参、附子，以接其真阳之气，方为紧要之治。也有寒中少阴，埋没真阳，肌肤皲裂无汗，又见种种寒象，可急用白通汤破阴散寒，以回其阳。若真阳素虚，腠理素疏，阴盛于内，逼阳于外，而汗出淋漓不止，则应急投通脉四逆加猪胆汁汤，补阳以摄阴，潜纳元阳以固根本。如果少阴寒盛于里，使人吐利交作，此时阴阳皆虚，治当阴阳兼顾。若单用白通汤治阳而遗阴，则势必劫阴走液，可发生心烦、干呕、无脉等证。同时，对原有厥利之证，而必加重。所以，治疗当用白通汤加人尿、猪胆汁，以“引阳入阴”达成“从治”之义，而且又能双补阴阳，而使阴阳自和。如果少阴病阳虚于下，镇水无权，则水气无制，而泛滥成灾，如水在上则见咳逆，水在中则见呕吐，水在下则见小便不利而大便泄泻，同证还可伴见头眩、心悸、筋惕肉瞤、振振欲擗地等证，治疗则用真武汤扶阳驱寒、镇水消阴。此外复有少阴病而脾肾阳气皆虚，元气不得充养，出现背部恶寒，而口中不燥，或脉微肢厥而骨节疼痛等证，治疗则用附子汤扶阳培元、温寒消阴以祛邪。

以上所述，实为四逆汤类治疗之大略。

一、四逆汤

【药物组成】

甘草（炙）二两 干姜一两半 附子（生用、去皮，破八片）一枚

【煎服法】

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。（强人可大附子一枚，干姜三两。）

【适应证】

治脉微细，但欲寐，或四肢厥逆，或自利而渴，小便清长，舌质淡，苔白润。

【原文】

第29条、91条、92条、225条、277条、323条、324条、353条、354条、372条、377条、388条、389条。

【方义】

《素问·至真要大论》曰：“寒淫于内，治以甘热。”本方以甘草为君，取其甘温，得干姜之辛热以温中散寒，得附子之辛热以温肾回阳，合为温补脾肾、回阳救逆之方。

【选注】

成无己：“《内经》曰：寒淫于内，治以甘热。又曰：寒淫所胜，平以辛热。甘草姜附相合，为甘辛大热之剂，乃可发散阴阳之气。”

《医宗金鉴》：“方名四逆者，主治少阴中外皆寒，四肢厥逆也。君以甘草之甘温，温养阳气；臣以姜附之辛温，助阳胜寒。甘草得姜附，鼓肾阳温中寒，有水中暖土之功。姜附得甘草，通关节走四肢，有逐阴回阳之力。肾阳鼓、寒阴消，则阳气外达而脉自升，手足自温矣。”

【按语】

本方是治疗三阴寒证的主方。如太阴病之腹痛下利、完谷不化，少

阴病之恶寒身蜷、脉微但欲寐，厥阴病之表热里寒、手足厥冷。此外，也有在三阳阶段误治，而使阳气大虚，或素体阳虚，复感外邪的少阴伤寒。总之，凡是疾病发展到心肾阳虚，而出现全身阳气不足，阴寒内盛的严重阶段，都可投用本方以回阳救逆。

本方能兴奋心肌，升高血压，促进血液循环，并增强胃肠功能，故常用本方配合治疗心肌梗死、心源性休克、脑血管意外，以及大出血、大汗出或大吐泻后而阳气虚衰等证。但是，附子含有乌头碱，如果服用剂量过大，煎煮时间又短，或对药物过于敏感，则可使人导致中毒。为了安全起见，用附子入药时，用慢火久煎，方能减低毒性。

【方歌】

四逆生附老干姜，炙草将将有专长；

少阴阳虚肢不暖，吐利烦躁欲寐方。

【医案选录】

唐叟，年逾古稀。冬月感寒，头痛发热，鼻流清涕。自服羚翘解毒丸六丸，自觉精神甚疲，而且手足发凉。其子悬余诊，切脉未久，唐即侧头欲睡，握其手，凉而不温。切其脉不浮而反沉，视其舌则淡嫩而白。余曰：此少阴伤寒，肾阳已虚，如再进凉药，恐生叵测，法当急温，以回肾阳。与四逆汤，服一剂，精神转佳。再剂，手足转温而愈。

（刘渡舟医案）

二、四逆加人参汤

【药物组成】

甘草（炙）二两 附子（生、去皮、破八片）一枚 干姜一两半 人参一两

【煎服法】

上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。

【适应证】

治疗虚寒下利，阳亡液脱，症见：恶寒，脉微，下利虽止而恶寒脉微等证仍在。

【原文】

第385条。

【方义】

四逆汤回阳救逆，加人参益气生津，为回阳复脉之法。

【选注】

成无己：“恶寒脉微而利者，阳虚阴胜也；利止则津液内竭，故云亡血，《金匱玉函》曰：水竭则无血。与四逆汤温经助阳，加人参生津液益血。”

张路玉：“亡血本不宜用姜附以损阴，阳虚又不当用归芍以助阴。此以利后恶寒不止，阳气下脱已甚，故用四逆以复阳为急也。其所以用人参者，不特护持津液，兼阳药得之，愈加得力耳。设误用阴药，必与腹满不食，或重加泄利呕逆，转成下脱矣。”

【按语】

陆渊雷云：“津伤而阳不亡者，其津自能再生，阳亡而津不伤者，其津无以后继。”本方立方之旨，仍以四逆汤温经回阳为本，以阳回而津方生。然大辛大热之剂，又恐有伤阴之弊，故加人参大补元气以生津血。如是则阳回阴复，方能转危为安。

临床凡见阳气虚衰，脉微欲绝，兼有亡血津枯者，皆可用本方治疗，不必囿于吐利之一端。

【方歌】

四逆加参治何为，下利多时阴亦摧；

四逆扶阳参滋血，更取中州化精微。

【医案选录】

张某，女性，中年。患者胸中满闷，手足发凉，脉搏沉迟。西医曾诊断为心动过缓症，但无有效疗法，转求中医诊治。予为处四逆加人参汤方，五、六剂痊愈，后未再发。

（摘《伤寒解惑论》）

三、茯苓四逆汤

【药物组成】

茯苓四两 人参一两 附子（生用、去皮、破八片）一枚 甘草（炙）二两 干姜一两半

【煎服法】

上五味，以水五升，煮取三升，去滓，温服七合，日二服。

【适应证】

治疗恶寒，四肢厥冷，下利清谷，烦躁，心悸，或小便不利，脉沉微。

【原文】

第69条。

【方义】

本方即四逆汤加人参、茯苓而成。方用四逆汤回阳救逆；加茯苓、人参补气益阴，宁心安神。

【选注】

成无己：“四逆汤以补阳，加茯苓、人参以益阴。”

柯韵伯：“未经汗下而烦躁，为阳盛；汗下后而烦躁，是阳虚。汗多既亡阳，下多又亡阴，故热仍不解。姜附以回阳，参苓以滋阴，则烦躁止而外热自除。此又阴阳双补法。”

【按语】

本方与四逆加人参汤同属回阳益阴之剂，但本方主治证候，较四逆加人参汤又多一烦躁证，故更增茯苓，以宁心安神。

【方歌】

茯苓四逆少阴虚，心肾阴阳已不支；

补阳生附姜甘草，扶阳参苓两药施。

【医案选录】

段某，素体衰弱，形体消瘦，患病年余，久治不愈。症见两目欲脱，烦躁欲死，以头冲墙，高声呼烦。家属诉：起初微烦头痛，屡经诊治，因其烦躁，均用寒凉清热之剂，多剂无效，病反增剧。面色青黑，精神极惫，气喘不足以息，急汗如油而凉，四肢厥逆，脉沉细欲绝。拟方如下：茯苓一两，高丽参一两，炮附子一两，炮干姜一两，甘草一两。急煎服之，服后烦躁自止。后减其量，继服十余剂而愈。

（摘《中医杂志》1965，1）

四、通脉四逆汤

【药物组成】

甘草（炙）二两 附子（生用、去皮、破八片，大者）一枚 干姜三两（强人可四两）

【煎服法】

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。（其脉即出者愈。）

【加减法】

面色赤者，加葱九茎；腹中痛者，去葱，加芍药二两；呕者，加生姜二两；咽痛者，去芍药，加桔梗一两；利止脉不出者，去桔梗，加人参二两。病皆与方相应者，乃服之。

【适应证】

治疗手足厥逆，下利清谷，汗出，身反不恶寒，面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出，舌淡，脉微欲绝。

【原文】

第317条、370条。

【方义】

本方与四逆汤药味相同，唯姜附用量较大，取大辛大热之剂，以破在内之阴寒，而壮少阴之阳气，庶外越之阳可返，欲绝之脉可复。

【选注】

陈修园：“阳气不能运行，宜四逆汤；元阳虚甚，宜附子汤；阴盛于下，格阳于上，宜白通汤；阴盛于内，格阳于外，宜通脉四逆汤。盖以生气既漓，亡在顷刻，若以柔缓之甘草为君，岂能疾呼散失之阳而使返耶！故倍用干姜而仍不减甘草者，恐散涣之余，不能当姜附之猛，还借甘草以收全功也。若面赤者，虚阳上泛也，加葱白引阳气以下行；腹中痛者，脾络不和也，去葱加芍药以通脾络；呕者，胃气逆也，加生姜

以宣逆气；咽痛者，少阴循经上逆也，去芍药之苦泄，加桔梗之开提；利止脉不出者，谷气内虚，脉无所禀而生，去桔梗加人参以生脉。”

【按语】

本方所主为阴盛格阳之证，其突出表现为：里寒外热，脉微欲绝，身反不恶寒，面色赤，反映阳气虚衰，阴寒内盛，阴阳格拒较四逆汤证更有亡阳欲脱之势，故急用本方宣通内外，破阴而回阳。

后世一些医家对本方的药物组成持有不同的看法，如柯韵伯、钱潢、汪琥等人认为本方条文中已明言有“脉微欲绝”、“面色赤”等证，故人参、葱白两药势在必用，不应附于方后待证而用。如方中无人参、葱白，则不得名“通脉”，此说应从。

【方歌】

通脉四逆草附姜，加重剂量另名方；
手足厥逆吐利甚，脉搏不出急回阳。

【医案选录】

李东垣治冯氏子，年十六。病伤寒，目赤而烦渴，脉七八至。医欲以承气下之，已煮药，而李适从外来，冯告之故，李切脉大骇曰：几杀此儿！《内经》有言，在脉诸数为热，诸迟为寒。今脉八九至，是热极也。殊不知《至真要大论》云：病有脉从而病反者何也？岐伯曰：脉至而从，按之不鼓，诸阳皆然。王注云：言病热而脉数，按之不动，乃寒盛格阳而致之，非热也。此传而为阴证矣。今持姜附来，吾当以热因寒用之法治之。药未就，而病者爪甲已青，顿服八两，汗渐出而愈。

（摘《名医类案·伤寒门》）

五、通脉四逆加猪胆汁汤

【药物组成】

甘草（炙）二两 干姜三两（强人可四两） 附子（生去皮、破八片）大者一枚 猪胆汁半合

【煎服法】

上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，内猪胆汁，分温再服，其脉即来。（无猪胆，以羊胆代之。）

【适应证】

治吐下之后，阳亡阴脱，吐无可吐，利无可利，更见汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝等症。

【原文】

第390条。

【方义】

本方即通脉四逆汤加猪胆汁而成。以通脉四逆汤峻补其阳，以消在内之阴；更佐猪胆汁，以滋阴液之虚，而敛浮游之热。

【选注】

成无己：“吐已下断，津液内竭，则不当汗出；汗出者，不当厥。今汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者，阳气大虚，阴气独胜也。若纯与阳药，恐阴为格拒，或呕或躁，不得复入也；与通脉四逆汤加猪胆汁，胆苦入心而通脉，胆寒补肝而和阴，引置阳药不被格拒。《内经》曰：微者逆之，甚者从之，此之谓也。”

【按语】

本方所主，系阳亡阴竭的危候，病势较通脉四逆更进一层。从条文来看，吐下已止，若肢温脉复，当是阳回欲愈的佳兆。今反见汗出而厥，四肢拘急，脉微欲绝，此乃阳亡于外，液脱于内的重证。病至如此，若单用通脉四逆汤回阳救逆，深恐阳药再伤其阴，又恐阴寒内拒而

药不得入，故于通脉四逆汤中再加猪胆汁之苦寒，既导阳入阴，又能和阴降逆。

【方歌】

通脉四逆治亡阳，再加胆汁救阴伤；
吐已下断烦呕甚，津液枯竭用此汤。

【医案选录】

周某，年届弱冠。大吐大泻之后，汗出如珠，厥冷转筋，干呕频频，面如土色，肌肉削弱，眼眶凹陷，气息奄奄，脉象欲绝，此败相毕露，许为不治矣。而病家苦苦哀求，姑尽最后手段，着其即觅大猪胆两个，处方用：炮附子三两，干姜五两，炙甘草九钱。一边煎药，一边灌猪胆汁，幸胆汁纳入不久，干呕渐止。药水频投，徐徐入胃矣。是晚再诊，手足略温，汗止，唯险证尚在。再处方：炮附子二两，川干姜一两五钱，炙甘草六钱，高丽参三钱，即煎继续投服。翌日巳时过后，其家人来说：“昨晚服药后呻吟辗转，渴饮，请先生为之清热。”观其意嫌昨日用姜附太多也。诂至则见病人虽有烦躁，但能诉出所苦，神志渐佳，诊其脉亦渐显露。凡此皆阳气复振机转，其人口渴，心烦不耐，腓肌硬痛等证出现，原系大吐大泻之后，阴液耗伤过甚，无以濡养脏腑肌肉所致。阴病见阳证者生，且云今早有小便一次，俱佳兆也。照上方加茯苓五钱，并以好酒用力擦其硬痛处。如是两剂而烦躁去，诸证悉减。再两剂而神清气爽，能起床矣。后用健运脾胃、阴阳两补诸法，佐以食物调养，数日复原。

（摘自《广东医学·祖国医学》1963，2）

六、真武汤

【药物组成】

茯苓三两 芍药三两 白术二两 生姜（切）三两 附子（炮去皮、破八片）一枚

【煎服法】

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

【加减法】

若咳者，加五味子半升、细辛一两、干姜一两；若小便利者，去茯苓；若下利者，去芍药，加干姜二两；若呕者，去附子，加生姜足前为半斤。

【适应证】

治心下悸，头眩，肌肉瞤动，四肢沉重或疼痛，体疲难支而振振欲擗地，腹痛，小便不利，或咳、或呕、或下利、或全身浮肿，舌质淡，苔白或水滑，脉沉微。

【原文】

第82条、316条。

【方义】

炮附子辛温大热，扶阳消阴；生姜辛温，散寒行水；茯苓、白芍利小便，伐水邪；白术健脾运湿，培土以制水。合为温阳消阴，驱寒镇水之剂。

【选注】

《医宗金鉴》：“用附子之辛热，壮肾之元阳，而水有所主矣；白术之苦燥，建立中土，而水有所制矣；生姜之辛散，佐附子以补阳，温中有散水之意；茯苓之淡渗，佐白术以健土，制水之中有利水之道焉。而尤妙在芍药之酸敛，加于制水主水药中，一以泻水，使子盗母虚，得

免妄行之患；一以敛阳，使归根于阴，更无飞越之虞。孰谓寒阴之品，无益于阳乎？”

【按语】

阳盛则动风，阴盛则动水，此乃病之常也。令水寒之邪由下而上，从内之外，或表或里，或上或下，浩浩荡荡，势不可遏，所以然者，肾阳虚衰不能镇水，而水寒之邪得以泛滥，故用真武汤扶阳以消阴，驱寒而镇水。

方中芍药除有监附子之悍以外，又有利尿去水之效。考《神农本草经》：芍药有“利小便”之说，亦不可不知。

据报道，本方对肺源性心脏病、风湿性心脏病续发心力衰竭的肢体浮肿之证，有可靠疗效。

【方歌】

真武名汤镇水寒，扶阳法中有心传；
附术苓芍生姜共，肉惕心悸小便难。

【医案选录】

滑伯仁治一人，七月内病发热。或令其服小柴胡汤，必二十六剂乃安。如其言服之，未尽二剂，则升散太过，多汗亡阳，恶寒甚，肉^瞤筋惕，乃请滑诊视。脉细欲无，即以真武汤进七八服，稍有绪，更服附子七八枚乃愈。

（摘《名医类案》）

七、白通汤

【药物组成】

葱白四茎 干姜一两 附子（生去皮、破八片）一枚

【煎服法】

上三味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

【适应证】

治少阴病背恶寒，手足厥逆，下利清谷，面赤，脉微或沉伏。

【原文】

第314条、315条。

【方义】

本方系四逆汤减甘草加葱白而成。方用姜附回阳以治厥；葱白宣通阳气以解阴凝。此方补阳之中而有散寒之义，故亡阳汗出者，则应忌服为告。

【选注】

《医宗金鉴》：“少阴病但欲寐、脉微细，已属阳为阴困矣。更加以下利，恐阴降极阳下脱也。故君以葱白，大通其阳而上升；佐以姜附，急胜其阴而缓降，则未脱之阳可复矣。”

【按语】

少阴病阳虚下利，治用四逆汤，理应愈矣。若服汤无效，而脉微反甚，此乃阴盛于内，阳气受阻而不得温，所以徒补阳而不破阴则力犹未尽，故改用白通汤治疗。

【方歌】

白通汤治少阴寒，阳虚下利非等闲；
葱白四茎姜附一，加入胆尿治呕烦。

【医案选录】

雷某，男，20岁，未婚。素常清早入河中捕鱼，一次偶感风寒，有轻微不适，自认为年壮体健不以为意，仍旧涉水捕鱼。回家时便发寒战，四肢逆冷，腹痛自利，口干舌燥，先请某医治疗。某医认为阴寒证，但又考虑口干舌燥，未敢断定，建议请我会诊。患者恶寒蜷卧，但欲寐，偶醒即呼口燥，索饮热茶，脉沉微，尺部更弱。我说：此少阴阴盛阳越证，急须人参四逆加葱白救治（即白通汤加味）。

遂处：炮附子四钱，干姜三钱，炙甘草二钱，横纹潞一两，葱白三茎。水煎分两次服。服后，利止、手足转温，诸证均愈。

（摘《伤寒论汇要分析》）

八、白通加猪胆汁汤

【药物组成】

葱白四茎 干姜一两 附子（生去皮，破八片）一枚 人尿五合 猪胆汁一合

【煎服法】

上五味，以水三升，煮取一升，去滓，内胆汁、人尿，和令相得，分温再服。（若无胆，亦可用。）

【适应证】

服白通汤不效，更见下利不止，厥逆无脉，干呕心烦等证。

【原文】

第315条。

【方义】

本方即白通汤加猪胆汁、人尿而成。白通汤破阴回阳，通达上下，加入人尿、猪胆汁之咸寒苦降，益阴滋液，除烦止呕，并能引阳入阴，使热药不致格拒，而更好地发挥回阳救逆的作用。

【选注】

《医宗金鉴》：“少阴病下利脉微者，与白通汤，下利当止。今利不止，而转见厥逆无脉，更增干呕而烦者，此阴寒盛极，格阳欲脱之候也。若喘以热药治寒，寒既甚，必反格拒而不入，故于前方中加人尿、猪胆之阴，以引阳药入阴。经曰：逆者从之，此之谓也。无脉者，言诊之而欲绝也。服汤后，更诊其脉，若暴出者，如烛烬焰高，故主死。若其脉徐徐微续而出，则是真阳渐回，故可生也。”

尤在泾：“少阴病，下利脉微者，寒邪直中。阳气暴虚，既不能固其内，复不能通于脉，故宜姜附之辛而温者，破阴固里；葱白之辛而通者，入脉引阳也。若服汤已，下利不止，而反厥逆无脉，干呕烦者，非药之不中病也，阴寒太甚，上为格拒。王太仆所谓：甚大寒热，必能与违性者争雄，异气者相格也。故急于白通汤中加人尿之咸寒、猪胆汁之

苦寒反其佐，以同其气，使不相格而适相成。《内经》所谓寒热温凉，反从其病是也。脉暴出者，无根之阳发露不遗，故死。脉微续者，被抑之阳来复有渐，故生。”

【按语】

本方用人尿、猪胆汁，不仅有“热因寒用”、“甚者从之”之意，亦取其滋阴补液、除烦止呕之功。临床应用时，多以童便为佳。本证属阴绝于下，阳越于上，阴阳即将离决的危重之候，故方中似应加入人参为是。由于证情凶险，服用本方后，仍可能出现两种机转：一为脉暴出，即由原来的脉微欲绝而突然变为浮大躁动，重按则无，此是孤阳无根的恶兆；一为脉微续，即脉搏逐渐恢复，乃阳复病退的佳象。

【方歌】

见白通汤方。

【医案选录】

王左，灼热旬余，咽痛如裂，舌红起刺且卷，口干不思汤饮，汗虽畅，表热犹壮，脉沉细，两尺空豁，烦躁面赤，肢冷囊缩。显然少阴证据，误服阳经凉药，苟读圣经，何至背谬如此？危险已极，计唯背城借一。但病之来源名目，虽经一诊道破，尚虑硬长莫及耳，勉拟仲圣白通汤加猪胆汁一法，以冀挽回为幸！

处方：淡附子二钱，细辛三分，怀牛膝一钱，葱白三个，上肉桂五分，左牡蛎七钱，猪胆汁一个，冲入微温服，其病得愈。

（摘《张聿青医案》）

九、附子汤

【药物组成】

附子（炮去皮，破八片）二枚 茯苓三两 人参二两 白术四两 芍药三两

【煎服法】

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

治少阴病背恶寒，手足冷，身体痛，骨节痛，口中和，舌淡苔白，脉沉微。

【原文】

第304条、305条。

【方义】

炮附子扶先灭之阳气；人参补后天之根本；白术、茯苓则助人参以补脾，更能协附子利水以消阴；白芍则监附子之燥热以和阴血。

【选注】

柯韵伯：“此大温大补之方，乃正治伤寒之药，为少阴固本御邪之剂也……此与真武汤似同而实异。此倍术附去姜而用参，全是温补以壮元阳；彼用姜而不用参，尚是温散以逐水气。补散之分歧，只在一味之旋转软。”

【按语】

本方参附合用，以峻补元阳之虚；术附合用，以去寒湿之邪；加芍药以监附子之悍。乃为正虚寒盛，身痛背寒的治法。背恶寒为少阴阳气虚衰的险兆，所以急用灸法以救阳气，然后用汤方不误事。

【方歌】

附子汤治背恶寒，脉沉口和阳气残；

参附苓术芍药共，更治妊娠腹如扇。

【医案选录】

陈某，男，30岁。初受外感，咳嗽愈后，但觉精神萎靡，食欲不振，微怕冷，偶感四肢腰背酸痛。自认为病后元气未复，未即就医治，拖延十余日，天天如是，甚感不适，始来就诊。脉象沉细，面色苍白，舌滑无苔，此乃脾肾虚寒，中阳衰馁。治当温补中宫，振奋阳气。附子汤主之。

处方：炮附子三钱，白术四钱，横纹潞三钱，杭芍（酒炒）二钱，茯苓三钱，水煎服。

服一剂后，诸证略有瘥减。次日复诊，嘱按原方续服二剂。过数日，于途中遇见，病者愉快告云：前后服药三剂，诸证悉愈，现已下田耕种。

（摘自《伤寒论汇要分析》）

杂方类概述

杂方类是指单见的一方一证，而无法进行集中归类，故归于一处加以论述。杂方类共有十一方。第一方是厚朴生姜甘草半夏人参汤，治疗汗后脾虚不运的腹胀满等证；第二方是茵陈蒿汤，治疗湿热发黄的口渴腹满等证；第三方是猪肤汤，治疗少阴虚热的咽痛和胸满心烦等证；第四方是桔梗汤，治疗少阴伏火咽痛，对甘草汤无效之证；第五方是苦酒汤，治疗咽中生疮，而语言难出等证；第六方是半夏散及汤，治疗风寒客阻少阴经脉，而咽中疼痛等证；第七方是乌梅丸，治疗厥阴病阴阳寒热错杂以及蛔厥等证；第八方是白头翁汤，治疗厥阴湿热下利，下重口渴等证；第九方是吴茱萸汤，治疗呕吐涎沫，胃脘疼痛，头颠作疼，手足厥冷，烦躁不安等证；第十方是烧裯散，治疗伤寒阴阳易证，而以身重少气，头重不举，膝胫拘急为凭；第十一方是牡蛎泽泻散，治疗大病瘥后，腰以下有水气等证。

一、厚朴生姜半夏甘草人参汤

【药物组成】

厚朴（炙去皮）半斤 生姜（切）半斤 半夏（洗）半升 甘草（炙）二两 人参一两

【煎服法】

上五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【适应证】

发汗或下后，损伤脾气而腹胀满。

【原文】

第66条。

【方义】

厚朴苦温，消胀除满；生姜味辛，健胃散痞；半夏辛滑治心下坚满，佐以人参、炙草补气健脾而复健运之能。此方消满而不伤正，补中而不滞邪，乃消补并行不悖之法。

【选注】

钱潢：“此虽阳气已伤，因未经误下，故虚中有实。以胃气未平，故以厚朴为君，生姜宣通阳气，半夏蠲饮利膈，故以为臣。参甘补中和胃，所以益汗后之虚耳。”

【按语】

脾虚不运，痰湿内生，阻碍气机，发而为胀。证属虚中挟实，故立三补七消之法，重用厚朴、生姜、半夏，除实消满；轻施甘草、人参，以补虚扶正。

【方歌】

厚朴夏姜参草寻，善治腹胀妙通神；

脾气不运痰气结，三补七消法超群。

【医案选录】

张石顽治陈孟庸，泻利腹胀作痛。服黄芩、白芍之类，胀急愈甚，其脉洪大而数，按之则濡，气口大三倍于人迎，此湿热伤脾胃之气也。与厚朴生姜半夏甘草人参汤二剂，痛止胀减，而泻利未已；与干姜黄芩黄连人参汤二剂，泻利止而饮食不思；与半夏泻心汤而安。

（摘《张氏医通》）

二、茵陈蒿汤

【药物组成】

茵陈蒿六两 栀子（擘）十四枚 大黄（去皮）二两

【煎服法】

上三味，以水一斗二升，先煮茵陈减六升，内二味，煮取三升，去滓，分三服。（小便当利，尿如皂荚汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。）

【适应证】

身目俱黄如橘子色，发热无汗，或头部汗出，剂颈而还，小便黄赤短少，大便不畅或秘结，腹微满，口渴心烦，或不欲饮食，或恶心呕吐，舌苔黄腻，脉弦滑数。

【原文】

第236条、260条。

【方义】

茵陈苦平微寒，清热利湿，又能清利肝胆而推陈致新，为治疗黄疸的要药；栀子苦寒，清泄三焦而通调水道；大黄苦寒，荡涤肠胃，以泻湿热蕴结之毒。三药和合，使湿热邪气从小便排泄，而发黄自能痊愈。

【选注】

《医宗金鉴》：“伤寒七八日，身黄色明，小便不利，其腹微满，此里热深也。故以茵陈蒿治疸病者为君；佐以大黄，使以栀子，令湿热从大、小二便泻出，则身黄腹满自可除矣。”

柯韵伯：“茵陈禀北方之色，经冬不凋，受霜承雪，故能除热邪留结；栀子以通水源，大黄以调胃实。令一身内外之瘀热悉从小便出，腹满自减而津液无伤，此茵陈汤为阳明利水之妙剂也。”

【按语】

本方是主治湿热发黄的方剂。药虽三味，但配伍严谨，疗效卓著。

茵陈一药，为治疗黄疸的专药，故用以为君；大黄泻热破结，栀子屈曲下行，故为臣使。茵陈在本方中宜先煎，大黄、栀子后下，则发挥治疗黄疸的作用。由于湿热黏腻之邪胶结难解，故在治疗时，还可单用茵陈一味煎汤代茶饮。

发黄一证，有阴阳之别。湿热郁蒸则发为阳黄，属阳明；寒湿内郁而发为阴黄，则属太阴。阳黄者，随其热与湿的轻重以及病情的偏表偏里，又分湿热并重而里有结滞、热重于湿而里无结滞和湿热兼表的不同。因此，在治疗上而有下汗、清法、汗法之异。本方所主，当属湿热并重，里有结滞的黄疸。夫湿热乃重浊之邪，常可导致腑气不利而出现腹满、大便不畅等证。本方中的大黄，主要导湿热以下行，非专以泻下为能事，故方后注云：“一宿腹减，黄从小便去也。”

目前临床用本方，随证加减化裁治疗急性黄疸型肝炎、暴发性肝炎，以及阻塞性黄疸等，若其病机属于湿热郁蒸发黄者，可取得满意疗效。

【方歌】

茵陈蒿汤治疸黄，阴阳寒热细推详；
阳黄大黄栀子入，阴黄附子与干姜。

【医案选录】

刘某，男，14岁。春节因食肥甘太过，又感受时邪，因而发病。症状有周身疲乏无力，心中懊^忪，不欲饮食，并且时时泛恶，小便黄短，而大便尚可。此病延至两日，而身目发黄，乃到某医院诊治，确诊为“急性黄疸型肝炎”，给中药六包，嘱每日服一包。服至四包，症状略有所减，而黄疸未退，乃邀余诊。脉弦滑数，舌苔黄腻。此时患童体疲殊甚，亦不能起立，饮食甚少，频频欲吐。此证乃肝胆湿热蕴郁不解之所致。

为疏：柴胡12克，黄芩9克，半夏10克，生姜10克，大黄6克，茵陈30克，生山栀10克。

此方书毕，有一同道问曰：此人太虚，应从补法入手为是，而君何以用大黄耶？余曰：此证本非虚，而体疲乏力者，为湿热所困故也。若湿热一去，则诸证自减。如果用补法，则必助邪，后果则难设想也。

上方连服三剂，而病愈大半。又服三剂，然后改用茵陈五苓散，乃逐渐痊愈。

（刘渡舟医案）

三、猪肤汤

【药物组成】

猪肤一斤

【煎服法】

上一味，以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白粉五合，熬香，和令相得，温分六服。

【适应证】

少阴下利，寒随利减，热从利生，咽喉疼痛，或声音嘶哑，并见胸满心烦等证。

【原文】

第310条。

【方义】

猪肤味甘微寒，能滋肾阴、润肺燥、退虚热；白蜜甘平，润燥养血，生津益阴；白米粉甘平，养脾益胃。三味合用，而有清虚热、润肺肾的作用，对少阴虚火上炎的咽喉肿痛极为合拍。

【选注】

成无己：“猪，水畜也，其气先入肾。少阴客热，是以猪肤解之，加白蜜以润燥除烦，白粉以益气断利。”

尤在泾：“猪水畜而肤甘寒，其气先入少阴，益阴除客热，止咽痛，故以为君。加白蜜之甘以缓急，润以除燥而烦满愈。白粉之甘能补中，温能养脏，而泄利止矣。”

【按语】

下利日久，脾胃气虚，阴津大耗，阴不制阳，虚火上炎，所以用猪肤润燥，白蜜生津，而米粉则补下后之虚。

综观全方，均为饮食之品，故本方具有食物疗法的意义。

【方歌】

猪肤斤许用水煎，水煎减半滓须捐；
再投粉蜜熬香服，少阴咽痛利且烦。

【医案选录】

徐君育，素禀阴虚多火，且有脾约便血证。十月间患冬温发热，咽痛。里医用麻仁、杏仁、半夏、枳橘之属，遂喘逆倚息不得卧，声飒如哑，头面赤热，手足逆冷，右手寸关虚大微数。此热伤手太阴气分也，与萎蕤、甘草、芍药不应。为制猪肤汤一瓯，令隔汤顿热，不时挑服，三日声清，终剂而痛如失。”

（摘《张氏医通》）

四、桔梗汤

【药物组成】

桔梗一两 甘草二两

【煎服法】

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，温分再服。

【适应证】

少阴病咽痛，若服甘草汤不效者。

【原文】

第311条。

【方义】

甘草清热解毒止痛，加桔梗则开结消肿，故治咽喉肿痛甚效。

【选注】

徐灵胎：“大甘为土之正味，能制肾水越上之火；不差，与桔梗汤，佐以辛开苦散之品。《别录》云：桔梗疗咽喉痛。”

【按语】

桔梗汤证的咽痛，比甘草汤证的咽喉痛而重。《金匱要略》用本方治疗肺痈“咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者。”反映了本方有清热解毒、消肿排脓的功效，而不容忽视。

【方歌】

甘草桔梗治咽痛，消炎解毒妙堪用；
阴中伏热结于喉，切忌苦寒投此证。

【医案选录】

马铭鞠治倪仲昭，患喉痹，邑中治喉者偏矣。喉渐渐腐去，饮食用

面粉之烂者，必仰口而咽，每咽，泣数行下。马曰：此非风火毒也，若少年曾患黧疮乎？曰：未也。父母曾患黧疮乎？曰然。愈三年而得我。马以为，此必误服升药之故……倘不以治结毒之法治之，必死。以甘桔汤为君，少入山豆根、龙胆草、射干，每剂用土茯苓半斤浓煎，送下牛黄二分，半月而痊。

（摘《古今医案按》）

五、苦酒汤

【药物组成】

半夏（洗、破如枣核）十四枚 鸡子（去黄，内上苦酒着鸡子壳中）一枚

【煎服法】

上二味，内半夏，著苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令三沸，去滓，少少含咽之。不差，更作三剂。

【适应证】

咽中伤生疮，或溃烂有脓液及分泌物，声音嘶哑，音不出者。

【原文】

第312条。

【方义】

苦酒解毒敛疮，活血消肿；鸡蛋清利血脉止痛，润喉而清音，半夏涤痰开喉痹，散结气。

【选注】

《医宗金鉴》：“半夏涤涎，蛋清敛疮，苦酒消肿，则咽清而声出也。”

【按语】

本方主药苦酒与鸡蛋清亦饮食之品，与猪肤汤用于虚热咽痛又是对比之方。苦酒即米醋，有消炎杀菌、解毒敛疮之功。鸡蛋清不仅滋润，还能通利血脉。少少含咽的服法，使药持续于患处，则其效更为理想。

陈蔚认为：一鸡子壳之小，安能纳半夏十四枚之多?.....余考原本，半夏洗破十四枚，谓取半夏一枚，洗其涎而破为十四枚。旧本破字模糊，翻刻落此一字，以致贻误之今，特正之。

【方歌】

半夏一枚十四升，鸡清苦酒搅几回；
刀环捧壳煎三沸，咽痛频吞绝妙哉。

【医案选录】

严某，男，石匠。咽中痛，声瘖，吞咽困难，脉象两寸独浮虚。诊断：少阴之经，循咽喉系舌本，阴火上炎而致咽喉中病变，处方苦酒汤。取鸡子白以清火润肺，半夏破结散邪，合苦酒酸以散瘀解毒。仅服一剂，痛止声开。次日邂逅相遇，道谢不已。

（摘《广东中医》1962，7）

六、半夏散及汤

【药物组成】

半夏（洗） 桂枝（去皮） 甘草（炙）

【煎服法】

上三味，等分，各别捣筛已，合治之。白饮和服方寸匕，日三服。若不能散服者，以水一升，煎七服，内散两方寸匕，更煮三沸，下火令小冷，少少咽之。（半夏有毒，不当散服。）

【适应证】

风寒阻于少阴经，故咽中疼痛，红肿不甚，痰涎较多。

【原文】

第313条。

【方义】

半夏开咽喉之痹，桂枝散风寒之结，炙甘草扶正和中。

【选注】

尤在泾：“少阴咽痛，甘不能缓者，必以辛散之；寒不能除者，必以温发之。盖少阴客邪郁聚咽嗑之间，既不得出，复不得入，设以寒治，则聚益甚；投以辛温，则郁反通，《内经》微者逆之，甚者从之之意也。半夏散及汤，甘辛合用，而辛胜于甘，其气又温，不特能解客寒之气，亦能劫散咽喉怫郁之热也。”

【按语】

《神农本草经》认为半夏主“咽喉肿痛”；桂枝治“结气喉痹”，所以风寒咽痛郁闭不解，可用本方治疗。

【方歌】

半夏研散或用汤，少阴咽痛效最彰；

半夏桂甘煎少与，微冷慢呷不用忙。

【医案选录】

郑某，家庭妇女，身体素弱，有痰嗽疾患。因取媳届期，心力俱劳引起恶寒、发热、疼痛等证，咽喉痛尤剧，卧床不起，吞咽困难，脉象两寸浮缓，咽部肤色不变。

诊断：三阴中少阴主枢，少阴之经循于咽喉，枢机失常，邪气拂逆，不自外达而发生咽痛。治疗：半夏汤原方。义取桂枝以解肌，甘草以清火，半夏散结降逆的表里兼治法。嘱徐徐咽下。服二剂，寒热痰嗽咽痛顿消，继以扶正而愈。

（摘《广东中医》1962）

七、乌梅丸

【药物组成】

乌梅三百枚 细辛六两 干姜十两 黄连十六两 当归四两 附子（炮去皮）六两 蜀椒（出汗）四两 桂枝（去皮）六两 人参六两 黄柏六两

【煎服法】

上十味，异捣筛，合治之。以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五斗米下，饭熟捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧桐子大。先食饮服十丸，日三服，稍加至二十丸。禁生冷、滑物、臭食等。

【适应证】

蛔厥腹痛，呕吐或吐蛔，时作时止，得食更甚，心烦不安，痛剧则手足厥冷。又主寒热错杂之久利。

【原文】

第338条。

【方义】

乌梅味酸，醋渍重用，养肝敛阴，安蛔止痛，为方中主药；细辛、干姜、附子、蜀椒温中散寒，杀虫驱蛔；黄连、黄柏清热燥湿；人参补脾益胃；当归养血柔肝。方中酸苦辛热并施，为调和肝胃，安蛔止痛之法。本方又有补气和血、酸涩固脱的作用，故又可治疗寒热错杂之久利。

【选注】

柯韵伯：“伤寒脉微厥冷烦躁者，在六七日，急灸厥阴以救之。此至七八日而肤冷，不烦而躁，是纯阴无阳，因藏寒而厥，不治之证矣。然蛔厥之证，亦有脉微肤冷者，是内热而外寒，勿遽认为藏厥而不治也。其显证在吐蛔，而细辨在烦躁。藏寒则躁而不烦，内热则烦而不躁。其人静而时烦，与躁而无暂安时迥殊矣。此与气上撞心，心中疼热，饥而不能食，食即吐蛔者，互文以见义也……看厥阴诸证，与本方相符，下之利不止，与又主久利相合，则乌梅丸为厥阴主方，非只为蛔

厥之剂矣。”

尤在泾：“古云：蛔得甘则动，得苦则安。又曰：蛔闻酸则静，得辛热则止。故以乌梅之酸、连柏之苦、姜辛桂附椒桂之辛，以安蛔温藏而止其厥逆。加人参者，以蛔动中虚，故以之安中而止吐，且以御冷热诸药之悍耳。”

【按语】

厥阴病为六经病中最末一经之病，是正邪交争的最后阶段。在此，邪正消长、寒热进退的矛盾表现得十分尖锐。由于阴阳胜复而不平衡，导致了寒热之证互见，成为厥阴病的一个特点。《医宗金鉴》说：“厥阴者，为阴尽阳生之藏，与少阳为表里。邪至其邪，从阴化寒，从阳化热，故其为病，阴阳错杂，寒热混淆也。”

本方用药虽比较繁杂，但配伍却是谨严。方中寒热并用，不仅能安蛔止痛，更有调和肝胃、分解寒热之功，与厥阴提纲证相符。故本方除治疗蛔厥证外，还应视为治厥阴病寒热错杂证的主方。

【方歌】

乌梅丸治蛔厥证，连柏干姜参归用；

川椒桂辛与附子，乌梅三百力始胜。

【医案选录】

阮某，女，23岁。腹中痛已历七日，食则更甚。时常呕酸，吐宿食，口渴而不欲饮。昨曾吐蛔虫三条。脉沉涩，舌苔白而干。拟属厥阴蛔痛，师乌梅丸意。

处方：乌梅五枚，川椒二钱，黄连二钱，黄芩二钱，吴茱萸三钱，半夏三钱，川芎三钱，苦楝根皮一两，槟榔六钱，茺莢四钱。

服两剂后，下蛔虫二条，各种症状均除。

（摘自《伤寒论汇要分析》）

八、白头翁汤

【药物组成】

白头翁二两 黄柏三两 黄连三两 秦皮三两

【煎服法】

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升。不愈，更服一升。

【适应证】

厥阴肝湿热下注而下利脓血，里急后重，身热心烦，渴欲饮水，腹痛，肛门灼热，小便短赤，舌红苔黄腻，脉弦滑数。

【原文】

第371条、373条。

【方义】

白头翁苦寒清热，凉血解毒；秦皮苦寒，清肝凉血；黄连清热厚肠；黄柏燥湿坚阴。为清热燥湿、解毒止利的有效之方。

【选注】

《医宗金鉴》：“三阴俱有下利证，自利不渴者，属太阴也；自利而渴者，属少阴也；唯厥阴下利，属于寒者，厥而不渴，下利清谷；属于热者，消渴下利，下重便脓血也。此热利下重，乃火郁湿蒸，秽气奔逼广肠，魄门重滞难出。即《内经》所云暴注下迫者是也。君白头翁，寒而苦辛；臣秦皮，寒而苦涩。寒能胜热，苦能燥湿，辛以散火之郁，涩以收下重之利也；佐黄连清上焦之火，则渴可止，使黄柏泻下焦之热，则利自除也。”

尤在泾：“伤寒热邪入里，因而作利者，谓热利。下利即后重，热邪下重，虽利而不得出也。白头翁苦辛除邪气，黄连、黄柏、秦皮苦以坚之，寒以清之，涩以收之也。”

【按语】

本方药物虽只四味，但配伍有度，为治厥阴湿热利的有效方剂。现常用此方治疗急性菌痢和阿米巴痢疾，临床实践证明有很好的疗效。但应注意，本方除了不适用于虚寒及寒湿下利以外，对舌红少苔的阴虚下利证，亦非所宜。若误投本方，则苦寒化燥，更伤其阴，反使病情严重。

【方歌】

白头翁汤下利寻，黄连黄柏白头秦；
识得欲饮属内热，下重难通此方珍。

【医案选录】

欧某，男，48岁。下利已十余日，始则小腹疼痛，里急后重，大便呈黏液状。近日所下多脓血，日行20余次，肛门有灼热感，口燥而苦，时时欲呕，饮食尚可，小溲短赤而热。此系湿热内聚胃肠，挟肝胆相火上逆，则口燥苦欲呕，下迫则为赤痢，饮食尚可，知非禁口痢。治从清热利湿，兼与疏肝利胆。

处方：小柴胡汤二两，白头翁四钱，秦皮三钱，黄连二钱，黄柏二钱。

复诊：大便次数减为一日十余次，里急后重稍差，余症同前。

处方：白头翁四钱，秦皮三钱，柴胡三钱，赤芍三钱，大黄四钱，黄芩、枳壳、半夏、黄柏、生姜各二钱，黄连一钱五分。连服两剂，下痢基本控制，腹痛欲呕均瘥。

（摘自《伤寒论汇要分析》）

九、吴茱萸汤

【药物组成】

吴茱萸（洗）一升 人参三两 生姜（切）六两 大枣（擘）十二枚

【煎服法】

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。

【适应证】

呕吐涎沫甚多，或干呕，或食谷欲呕，或呕吐酸水，胃脘痛，头巅痛，手足不温，或有腹泻烦躁等证，舌淡苔白滑，脉沉弦迟。

【原文】

第243条、309条、378条。

【方义】

吴茱萸苦辛大热，苦以降逆，温以去寒，是治肝胃气逆、呕吐涎沫的要药；生姜辛温，长于止呕，辅佐吴茱萸温中散寒，降逆和胃；人参、大枣甘温滋润，补中益气，以扶正虚。

【选注】

汪琥：“呕为气逆，气逆者必散之。吴茱萸辛苦，味重下泄，治呕为最。兼以生姜，又治呕圣药，非若四逆中之干姜守而不走也。武陵陈氏云其所以致呕之故，因胃中虚生寒，使温而不补，呕终不愈，故用人参补中，合大枣以为和脾之剂焉”。

【按语】

本方在《伤寒论》中凡三见。一见阳明胃气虚寒呕吐；二见少阴寒气犯胃呕吐；三见厥阴寒饮浊气上逆呕吐。因皆有胃寒呕吐一证，故均用吴茱萸汤治疗。若少阴寒甚迫胃，可兼见手足厥冷、下利等证；若肝寒循经上逆，亦可见到巅头痛等证，可见本方治寒性呕吐为所长。

郭雍在《伤寒补亡论》中说：“凡寒厥，手足逆冷而烦躁的，不论其它余证，当先服吴茱萸汤；如手足厥逆不见烦躁者，当先与四逆汤；

如果手足厥逆而又下利，脉沉微不见者，则当急服通脉四逆汤。”指出了治疗少阴病寒证的方法和规律。

本方加附子，名吴茱萸加附子汤，治寒疝腰痛，牵引睾丸，尺脉沉迟等证。

【方歌】

吴茱萸汤暖胃肝，呕吐涎水痛在巅；
萸姜人参与大枣，温中降逆治阴寒。

【医案选录】

阎某，男，37岁。患十二指肠球部溃疡已一年有余，某医院外科建议手术治疗。其病发作，常于每夜十二时左右，见左下腹胀痛，呕吐反酸，周身寒战，头目眩晕。察脉弦缓，舌质淡嫩，苔白而润。此证从舌脉看，反映了肝胃寒邪上逆之象。子夜而阴盛，故病发胀痛呕吐；而阴来搏阳，故见寒战。为疏吴茱萸汤：

吴茱萸12克，生姜12克，党参9克，大枣12枚。

服二剂，诸证皆减，唯大便发干，原方加当归9克，共服12剂，其病得愈。

（摘自《伤寒论通俗讲话》）

十、烧 裯 散

【药物组成】

妇人中裯近隐处，取烧作灰。

【煎服法】

上一味，水服方寸匕，日三服。小便即利，阴头微肿，此为愈矣。妇人病取男子裯烧服。

【适应证】

阴阳易为病，其人身重少气，小腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急。

【原文】

第392条。

【方义】

此方能导阴中邪热以从小便而出，男病用女，女病用男，取同气相求之义。

【选注】

成无己：“大病新差，血气未复，余热未尽，强合阴阳得病者名曰易。男子病新差未平复，而妇人与之交，得病名曰阳易；妇人病新差未平复，男子与之交，得病名曰阴易。以阴阳相感动，其余毒相染著，如换易也。其人病身体重，少气者，损动真气也；少腹里急，引阴中拘挛，膝胫拘急，阴气极也；热上上胸，头重不欲举，眼中生花者，感动之毒、所易之气熏蒸于上也。与烧裯散以通阴气。”

【按语】

阴阳易和房劳复是两种病，不能混为一谈。此病历代医学文献中均有记载，近代医家如山西李汉卿曾亲手治愈数例有案可稽。

本证若见阴虚有热的，可用白薇、花粉、竹茹等清热养阴之品送服烧裯散。若阳虚有寒的，多以四逆汤或理中汤送服烧裯散。

此病多见于男性。服药后，以“小便即利，阴头微肿”为验。

【方歌】

近阴裨裆剪来烧，研末还须用水调；
同气相求疗二易，长沙无法不翘翘。

【医案选录】

张路玉治冯茂之，夏月阴阳易，两腰痛少腹急，烦躁谵妄，舌色青紫而中有黄苔肿裂，虽渴欲饮冷，而舌却不甚干，心下按之硬痛，噤而矢气，此挟宿食也。所可虑者，六脉虚大，而两尺则弦，按之皆无根耳。遂以逍遥汤加大黄一剂，下黑秽甚多。下后诸证悉除，但少腹微冷作痛，又于烧裨散一服，煎五苓散送下而安。

（摘《古今医案按》）

十一、牡蛎泽泻散

【药物组成】

牡蛎（熬） 泽泻 蜀漆（暖水洗去腥） 葶苈子（熬） 商陆根（熬） 海藻（洗去咸） 栝蒌根各等分

【煎服法】

上七味，异捣，下筛为散，更于臼中治之，白饮和服方寸匕，日三服。小便利，止后服。

【适应证】

治大病差后，腰以下有水气，按之凹陷，二便不利，脉沉有力。

【原文】

第395条。

【方义】

牡蛎入肝，软坚以消痞；泽泻滋阴导水而下行；瓜蒌根生津清热；商陆根峻逐水邪；海藻软坚行气；蜀漆劫痰化水；葶苈泻肺利水。其皆走而不守，有泄热逐水之效。

【选注】

陈修园：“牡蛎、海藻生于水，故能行水，亦咸以软坚之义也；葶苈利肺气而导水之源；商陆攻水积而疏水之流；泽泻一茎直上，栝蒌生而蔓延，二药皆引水液而上升，可升而后可降也；蜀漆乃常山之苗，自内而出外，自阴而出阳，所以引诸药而达于病所。又散以散之，欲其散布而行速也。但其性甚烈，不可多服，不可作汤，以商陆根煎服杀人。”

【按语】

本方用于正气不衰的实性水肿，以下肢水肿与腹水不消为特征。牡蛎配栝蒌根，用以养阴清热，活血软坚，是针对病之本在于肝而设；其余五药，攻利水邪，则是针对病之标在于三焦而设，故本方治肝硬化腹

水而实有良效。

【方歌】

牡蛎泽泻治如何，下肢肿胀病未瘥；
商陆葶苈泻水结，蜀漆海藻破坚邪。

【医案选录】

某男，脉如涩，凡阳气动则遗，右胁汨汨有声，坠水少腹，可知肿胀非阳道不利，是阴道实，水谷之湿热不化也。议用牡蛎泽泻散：左牡蛎、泽泻、花粉、川桂枝木、茯苓、紫厚朴，午服而愈。

（摘《临证指南医案》）



现代著名老中医名著重刊丛书

刘渡舟医书七种

金匱要略

詮解

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编
■ 刘渡舟 苏宝刚 庞鹤 编著

第十辑



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·第十辑
刘渡舟医书七种

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编



金匱要略 詮解

編著 刘渡舟 苏宝刚 庞 鹤

人民卫生出版社

版权页

图书在版编目（CIP）数据

金匱要略詮解 / 刘渡舟等编著. —北京：人民卫生出版社，2013
（现代著名老中医名著重刊丛书. 第10辑，刘渡舟医书七种）

ISBN 978-7-117-17355-1

I. ①金... II. ①刘... III. ①《金匱要略方论》—研究 IV.
①R222.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第158508号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购
书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

现代著名老中医名著重刊丛书（第十辑）

刘渡舟医书七种

金匱要略詮解

丛书主编：王庆国 刘燕华

编 著：刘渡舟 苏宝刚 庞 鹤

出版发行：人民卫生出版社有限公司
人民卫生电子音像出版社有限公司

地 址：北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编：100021

E - mail: ipmph@pmph.com

制作单位：人民卫生电子音像出版社有限公司

排 版：人民卫生电子音像出版社有限公司

制作时间：2019年5月

版本号：V1.0

格式：mobi

标准书号：ISBN 978-7-117-17355-1

策划编辑：李丽

责任编辑：李丽

打击盗版举报电话：**010-59787491** E-mail: **WQ @ pmph.com**

注：本电子书不包含增值服务内容，如需阅览，可购买正版纸质图书。

刘渡舟医书七种编写委员会

主 编 王庆国 刘燕华

副主编 李宇航 梁永宣

编 委（以姓氏笔画为序）

于博睿 马小娜 马春雷 王 冬 王庆国

王国华 王利敏 王雪茜 刘 敏 刘丹彤

刘晓倩 刘晓辉 刘燕华 闫军堂 许仲宁

孙 燕 孙良明 孙晓东 李 欣 李成卫

李宇航 李丽娜 李晓莉 李鹏英 吴范武

张 欢 张 娜 张雪亮 陈 明 陈 萌

畅洪昇 周 刚 郑丰杰 房克英 屈会化

赵 妍 赵 琰 赵伟鹏 赵宇明 钟相根

贾春华 倪 磊 高 飞 郭书文 梁永宣

程发峰 傅延龄 鲁 艺 赛佳洋

学术秘书 闫军堂

出版说明

自20世纪60年代开始，我社先后组织出版了一些著名老中医经验整理著作，包括医案、医论、医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国现代中医学术的发展发挥了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显。这些著名老中医在我国近现代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。他们的著作多成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前。无论是亲自撰述，还是口传身授，或是由其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华。诸位名老中医不吝秘术，广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，今已很难见到，部分著作甚至已成为中医读者的收藏珍品。为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将部分具有较大影响力的名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》并分辑出版，以飨读者。

第一辑 收录13种名著

- | | |
|-------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |

《钱伯煊妇科医案》 《朱小南妇科经验选》
《赵心波儿科临床经验选编》 《赵锡武医疗经验》
《朱仁康临床经验集——皮肤外科》
《张赞臣临床经验选编》

第二辑 收录**14**种名著

《中医入门》 《章太炎医论》
《冉雪峰医案》 《菊人医话》
《赵炳南临床经验集》 《刘奉五妇科经验》
《关幼波临床经验选》 《女科证治》
《从病例谈辨证论治》 《读古医书随笔》
《金寿山医论选集》 《刘寿山正骨经验》
《韦文贵眼科临床经验选》 《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑 收录**20**种名著

《内经类证》 《金子久专辑》
《清代名医医案精华》 《陈良夫专辑》
《清代名医医话精华》 《杨志一医论医案集》
《中医对几种急性传染病的辨证论治》
《赵绍琴临证400法》 《潘澄濂医论集》
《叶熙春专辑》 《范文甫专辑》
《临诊一得录》 《妇科知要》
《中医儿科临床浅解》 《伤寒挈要》
《金匱要略简释》 《金匱要略浅述》
《温病纵横》 《临证会要》

《针灸临床经验辑要》

第四辑 收录**6**种名著

《辨证论治研究七讲》 《中医学基本理论通俗讲话》

《黄帝内经素问运气七篇讲解》 《温病条辨讲解》

《医学三字经浅说》 《医学承启集》

第五辑 收录**19**种名著

《现代医案选》 《泊庐医案》

《上海名医医案选粹》 《治验回忆录》

《内科纲要》 《六因条辨》

《马培之外科医案》 《中医外科证治经验》

《金厚如儿科临床经验集》 《小儿诊法要义》

《妇科心得》 《妇科经验良方》

《沈绍九医话》 《著园医话》

《医学特见记》 《验方类编》

《应用验方》 《中国针灸学》

《金针秘传》

第六辑 收录**11**种名著

《温病浅谈》 《杂病原旨》

《孟河马培之医案论精要》 《东垣学说论文集》

《中医临床常用对药配伍》 《潜厂医话》

《中医膏方经验选》 《医中百误歌浅说》
《中药炮制品古今演变评述》 《赵文魁医案选》
《诸病源候论养生方导引法研究》

第七辑 收录**15**种名著

《伤寒论今释》 《伤寒论类方汇参》
《金匱要略今释》 《杂病论方证捷咏》
《金匱篇解》 《中医实践经验录》
《罗元愷论医集》 《中药的配伍运用》
《中药临床生用与制用》 《针灸歌赋选解》
《清代宫廷医话》 《清宫代茶饮精华》
《常见病验方选编》 《中医验方汇编第一辑》
《新编经验方》

第八辑 收录**11**种名著

《龚志贤临床经验集》 《读书教学与临症》
《陆银华治伤经验》 《常见眼病针刺疗法》
《经外奇穴纂要》 《风火痰瘀论》
《现代针灸医案选》 《小儿推拿学概要》
《正骨经验汇萃》 《儿科针灸疗法》
《伤寒论针灸配穴选注》

第九辑 收录**11**种名著

《书种室歌诀二种》 《女科方萃》
《干祖望医话》 《名老中医带教录》
《班秀文妇科医论医案选》 《疑难病证治》
《清宫外治医方精华》 《清宫药引精华》
《祝谌予经验集》 《疑难病证思辨录》
《细辛与临床》（附 疑难重奇案七十三例）

第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）

《伤寒论十四讲》 《伤寒论通俗讲话》
《伤寒论诠解》 《新编伤寒论类方》
《经方临证指南》 《金匮要略诠解》
《肝病证治概要》

这些名著大多于20世纪60年代前后至90年代后在我社出版，自发行以来一直受到广大读者的欢迎，其中多数品种的发行量达到数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床诊疗水平和促进中医事业发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时尽可能保持原书原貌，只对原著中有欠允当之处及疏漏等进行必要的修改。为不影响原书内容的准确性，避免因换算等造成的人为错误，对部分以往的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的临床检测项目与方法等，均未改动，保留了原貌。对于原著中犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社
2013年3月

整理说明

刘渡舟是北京中医药大学已故终身教授、《伤寒论》专业首批博士生导师，当代著名的中医学大家、中医教育家。刘老行医、执教半个多世纪，上溯岐黄之道，下逮诸家之说，力倡仲景之学，博采众长，学验宏富，形成了鲜明的学术思想和医疗风格，被誉为“伤寒泰斗”、“经方大家”，日本汉方界更称其为“中国治伤寒第一人”，其学术成就为中医同仁所公认，在中医学界享有盛誉。刘老以振兴中医、培育桃李为己任，在繁忙的医疗、教学、科研之余，坚持著书立说，笔耕不辍，培养后学。刘老一生著述颇丰，曾出版中医学术著作20多部，发表学术论文100余篇，为传承中医药事业作出了杰出贡献。

20世纪80年代，刘老的学术经验日臻成熟与完善，在当时十多年的时间里，他出版了数十部关于《伤寒论》、《金匱要略》及经方运用的研究专著，具有很高的学术水平和临床应用价值，深受广大读者欢迎，在中医学界产生了很大的影响，对于推动仲景学术发展和提高中医临床水平起到了重要的作用。为了系统总结刘老的学术思想和医疗经验，并从中窥探其治学方法与道路，我们精选了最能反映刘老治伤寒、用经方、精临证的学术著作，经撰次整理，辑而成帙，名为《刘渡舟医书七种》，付梓再版，以飨读者。这7本代表性医书分别是《伤寒论十四讲》、《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论诠解》、《新编伤寒论类方》、《经方临证指南》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》。这些著作能突出反映刘老之方证相对论、辨证知机论、古今接轨论、气机论、攻邪论、水火论、湿证论、脾胃论、肝胆论以及抓主证等学术思想及其对经方的运用经验，汇集了刘老行医50余年的学术经验和心血结晶，贯彻了理论和实践相结合的方针。通过阅读刘老文稿，读者可窥其学术思想和临床经验之一斑，并有助于系统地掌握刘老的临证特色和诊治经验。编撰者也希望通过这些文字笔墨展示经方大家刘渡舟教授的学术经历及成就，使一代名家为中医药事业不屈不挠的奋斗精神、人格品质及宝贵经验得以传世后人，为中国医学史树起一座不朽的丰碑。

为了使读者能原汁原味地阅读刘老著作，本次修订再版《刘渡舟医

书七种》时，采取尽可能保持原书原貌的原则，除对原著中出现的文字、标点错误稍加更正，并在不影响文意的前提下润色语句不通顺之处外，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排，从而规范了原书的体例层次。而对原书中出现的古今字、异体字、繁简字以及以往的病名、药名、计量单位等，均未改动，保留了原貌。

2007年，为了整理、挖掘、继承和抢救京城名老中医的学术经验，北京市中医管理局启动了“名老中医药专家学术思想抢救挖掘与优秀传承人才培养联动工程”（简称“薪火传承3+3工程”），目的在于做好首都名老中医学术思想的抢救、整理和挖掘工作。刘渡舟名家研究室

（No.2007-SZ-A-09）于2007年10月首批获北京市中医管理局批准，2008年1月授牌，2008年6月正式启动建设，进行了大量卓有成效的工作。将刘老积累多年的学术著作、文章、讲稿等整理、汇编、出版更是研究室的重要工作之一，本书即是在研究室全体成员的共同努力之下完成的，在此，谨向名家研究室这一名老中医学术经验平台的发起者——北京市中医管理局致以崇高的敬意。同时，也向所有参与此次编撰工作的各位同仁致以谢意。

刘渡舟名家研究室主任
北京中医药大学副校长，教授、博士生导师
王庆国
2012年12月

前言

《金匱要略方論》一書是東漢著名醫學家張仲景所著，是我國醫學文獻中最早的一部辨治雜病的方書。但因其文字古奧，不加講解，很難掌握全貌，領會原著精髓。為此，我們在編寫《金匱要略詮解》時參閱了有關注家的注釋，並結合自己的教學和臨床體會，對原文作了較深入的分析和講述。在詮解原文時，力求按着疾病的客觀規律，闡述疾病的病因、病機、證候特點，以及疾病的傳變規律。遵照張仲景辨證論治的思維方法，說明《金匱要略方論》辨證、立法、處方用藥的規律。為了進一步探討張仲景的學術思想，在詮解原文時指出書中的治略思想和意義。對於一些前人存有疑問的條文、附方，我們通過學習、考證，作了一些必要的解釋和校勘，以供讀者參考。

《金匱要略方論》原書共25篇，第一篇《臟腑經絡先後病脈證》相當於全書的總論；第二篇《痙濕喝病脈證》至第十七篇《嘔吐下利病脈證治》廣泛地論述了內科方面的各種疾病；第十八篇《瘡痈腸痈浸淫病脈證并治》論述了外科的疾病；第十九篇《跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蝨蟲病脈證治》論述了幾種不便歸納的病證。第二十篇至第二十二篇論述了婦科的疾病，以上22篇共有條文396條。對上述條文除系統地進行了詮解外，並附有相應的選注和醫案。最後三篇論述了《雜療方》和《禽獸魚蟲禁忌并治》、《果實菜谷禁忌并治》。但仲景原著因受歷史條件所限，其中不免雜有一定的封建迷信糟粕，尤其在最後三篇，其中不少內容還有待商榷。鑑於其對研究我國古代的飲食衛生和食物中毒的防治仍有一定的參考價值，故未加刪節，希望讀者遵照“古為今用”、“推陳出新”的方針，去粗取精，有分析批判地閱讀。

因我們水平有限，本書一定有許多缺點和不足之處，敬希讀者批評指正。

編著者
1983年於北京中醫學院

金匱要略方論序

张仲景为《伤寒杂病论》合十六卷，今世但传《伤寒论》十卷，杂病未见其书，或于诸家方中载其一二矣。翰林学士王洙在馆阁日，于蠹简中得仲景《金匱玉函要略方》三卷：上则辨伤寒，中则论杂病，下则载其方，并疗妇人，乃录而传之士流，才数家耳。尝以对方证对者，施之于人，其效若神。然而或有证而无方，或有方而无证，救疾治病其有未备。国家诏儒臣校正医书，臣奇先校定《伤寒论》，次校定《金匱玉函经》，今又校成此书，仍以逐方次于证候之下，使仓卒之际，便于检用也。又采散在诸家之方，附于逐篇之末，以广其法。以其伤寒文多节略，故断自杂病以下，终于饮食禁忌，凡二十五篇，除重复合二百六十二方，勒成上、中、下三卷，依旧名曰“金匱方论”。臣奇尝读《魏志·华佗传》云：出书一卷曰：“此书可以活人。”每观华佗凡所疗病，多尚奇怪，不合圣人之经。臣奇谓活人者，必仲景之书也。大哉！炎农圣法，属我盛旦，恭惟主上丕承大统，抚育元元，颁行方书，拯济疾苦，使和气盈溢，而万物莫不尽和矣。

太子右赞善大夫臣高保衡、尚书都官员外郎臣孙奇、尚书司封郎中充秘阁校理臣林亿等传上。

凡例

一、本书编写是以《医统正脉》本为蓝本（即人民卫生出版社，1972年8月重印《金匱要略方论》）。

二、本书编写体例

1. 每篇前冠以概说，介绍本篇讲述的重点内容。
2. 每篇末有结语，总结本篇的主要精神。
3. 条文词解 对条文中难懂的名词、术语以白话文加以解释。
4. 条文诠释 力求通俗易懂地对条文的内容从理论到实践予以注解。
5. 选注 选用历代名注作理解条文的参考。
6. 医案举例 选用有关病案，以达到理论与实践相结合。
7. 校勘 参阅一些古籍作了部分校勘。校勘统一放在正文之后。

目录

脏腑经络先后病脉证第一

概说

结语

痉湿喝病脉证第二

概说

结语

百合狐惑阴阳毒病证治第三

概说

结语

疟病脉证并治第四

概说

结语

中风历节病脉证并治第五

概说

结语

血痹虚劳病脉证并治第六

概说

结语

肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七

概说

结语

奔豚气病脉证治第八

概说

结语

胸痹心痛短气病脉证治第九

概说

结语

腹满寒疝宿食病脉证治第十

概说

结语

五脏风寒积聚病脉证并治第十一

概说

结语

痰饮咳嗽病脉证并治第十二

概说

结语

消渴小便不利淋病脉证并治第十三

概说

结语

水气病脉证并治第十四

概说

结语

黄疸病脉证并治第十五

概说

结语

惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六

概说

结语

呕吐哕下利病脉证治第十七

概说

结语

疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八

概说

结语

趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九

概说

结语

妇人妊娠病脉证并治第二十

概说

结语

妇人产后病脉证治第二十一

概说

结语

[妇人杂病脉证并治第二十二](#)

[概说](#)

[结语](#)

[杂疗方第二十三](#)

[概说](#)

[结语](#)

[禽兽鱼虫禁忌并治第二十四](#)

[概说](#)

[结语](#)

[果实菜谷禁忌并治第二十五](#)

[概说](#)

[结语](#)

[附：《金匱要略方论》原文校勘](#)

[【血痹虚劳病脉证并治第六】](#)

[【惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六】](#)

[【杂疗方第二十三】](#)

[返回总目录](#)

脏腑经络先后病脉证第一

概说

本篇为全书的总论，内容相当广泛，对疾病的病因、病机、诊断、治疗、预防，以及季节气候对人体脏腑的影响等，都作了一些原则性的论述。篇中共有条文十七条，其中第一、二、七、八、十条以整体观念论述了疾病发生的原因、传变规律、气候对人体的影响，提出了“不治已病治未病”的观点，强调预防疾病重于治疗疾病的思想。第三条至第六条阐述了望诊与闻诊在诊断疾病上的各种方法。第九、十一、十二条阐述了脉诊对判断各种疾病的性质、部位、转归的方法。第十三条叙述了疾病的分类方法。第十四至十七条阐明了对各种疾病总的治疗原则和方法。

本篇着重说明脏腑经络病理变化所产生的不同证候，并提示辨证应根据脏腑经络的病机反映进行分析，然后确定治疗法则。又根据疾病传变的整个过程，确定出全面的治略思想，还根据疾病的部位、性质而确定具体的治疗方法。以上这些内容，是全书的主要精神。

1.问曰：上工治未病，何也？师曰：夫治未病者，见肝之病，知肝传脾，当先实脾，四季脾王不受邪，即勿补之。中工不晓相传，见肝之病，不解实脾，惟治肝也。夫肝之病，补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之。酸入肝，焦苦入心，甘入脾。脾能伤肾，肾气微弱，则水不行；水不行，则心火气盛则伤肺；肺被伤，则金气不行；金气不行，则肝气盛，则肝自愈。此治肝补脾之要妙也。肝虚则用此法，实则不在用之。经曰：虚虚实实，补不足，损有余，是其义也。余藏准此。

【词解】

上工：指高明的医生。中工：指普通的医生。

治未病：治未病的脏腑，如见肝之病，当先实脾之例。

实脾：补脾。

四季脾王：王同旺。四季脾王，指春、夏、秋、冬每季的最后十八天，为脾土旺时，脾气得王时而不虚，这样就不要先实脾。

伤：在这里有制伏的意思。

【诠解】

本条是以整体观念论述疾病的治疗法则。人体五脏六腑之间存在着生克制化的关系，在正常时有相互资生的一面，发病时又有相互克制的一面。如一脏有病，并不局限本脏，还可以影响其他的脏腑发病，而且有一定的传变规律。为此，我们治病时，就不能只看见已病的脏腑，还应注意未病之脏腑。那么，怎样去辨知未病的脏腑，以防止疾病的传变？张仲景提出了脏腑经络疾病传变的规律，就解决了这一问题。如见肝之病，便知肝病最易传之于脾。所以，在治病时当先实脾，而先治未病之脾，以防止疾病传脾，这样考虑问题是上工的水平。但是，如果在四季脾旺的时候，而脾不受肝邪，即勿用补脾之法。另一说：凡是一年四季脾脏正气充实而不受邪侵的，则可不拘泥治肝实脾之说，至于一般的中工，他们不解治肝实脾之理，而见到肝病，只知一味去治肝，不了解实脾的意义，就不能做到杜绝疾病传变的途径。只有知道疾病相传的规律，才能胸怀治未病的要略，才可以取得满意的疗效。

以上为肝伤脾后肝实证的治疗规律。而肝虚证又分三种治法，即肝虚病要补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之。夫酸味入肝，可补肝之体，此其一。焦苦入心，使心气旺，而有助于肝，此其二。益用甘味之药，则有实脾以制肾的思想，而使肾水弱则心火旺；心火旺则肺气亦衰，而肝木不受其制，则肝旺而自愈，此其三。这种治肝补脾的方法，而具有微妙的哲理在内。归纳起来讲；肝虚用酸补之，此为正治法；助用焦苦，补心气，“子能令母实”，此为隔一治法；甘药入脾，益脾所以胜肾，而使火旺以刑金，则使肺金不伤肝木，此为隔二的治法。凡临床治病，以此为例，必须明确上述的三治方法，才能提高医疗水平。

最后，作者引用了《内经》之文，指出对虚实之证如果不是这样的治法，那就难免虚证而反用泻法，实证而反用补法，成为治疗之逆。而应当是虚者补之，实者泻之，补其不足，损其有余，才是虚实两证的正确治疗方法。肝病如此，心、肺、脾、肾等脏，以此类推，所以说：“余脏准此”。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“肝病必传于脾，上工必先实脾，使肝病不得传而可愈也。然脏气之衰旺，与时令相流通。四季之月，每季土旺十八日，合算畸零，以应五行各旺七十二日之数，若适当其际，则脾旺

自不受邪，即勿补之，而肝自不得肆其侮也。设过补脾，又犯实实之戒矣。但此衰旺消息之理，上工方知之，若中工不晓相传之义，见肝之病不解实脾，惟治肝也。夫肝之病，必肝虚者多，虚者补之，补必用酸，正治也。若夫助其子势，即以助母之势也。焦苦入心，助心必用焦苦，此旁治也。更有益其所胜之势，即以衰其病之势矣。甘入脾，益脾必用甘味以调济之，此又反治也。明乎三治之治，而预图之，何病不已乎。所以然者，脾能伤肾，肾气微弱则水不行，此水为阴寒之水气，足以入厥阴而伤及少阳者，故水不行而心火气足，不食肝母之气，而肝自安，故心火足而肝阳畅达，木得火而欣欣向荣必也。且于是而肺金畏火制而不敢来侮肝，故曰伤，然非真伤肺也。使顽燥之气不伐厥阴生意，而肺金常得温，故云和，金气乃不行也。金气不行，则肝木畅茂条达而病自愈矣。一治肝之法，而辗转顾虑于五行之理，盖如是之周详缜密，而后可善其治肝之用也。此治肝必补脾之要妙也，非上工庸易明哉。肝之虚者必用此法，而肝实者则不在此例，用此治。然实邪易泄，虚病难调，知补虚之法，而泻实之法自能类推矣。师又引经以总结之，经曰虚虚实实，补不足损有余。盖虚者复攻之是犯虚虚之禁也，实者复补之是犯实实之禁也。惟虚而不足者补之，实而有余者损之，方合于经言之义也乎。学者再能邪正标本之间，辨虚实而为补损，则于师神明之旨方有契焉。师更明余脏准此，举一隅而可以三隅反矣。”

2.夫人禀五常，因风气而生长，风气虽能生万物，亦能害万物。如水能浮舟，亦能覆舟。若五脏元贞通畅，人即安和，客气邪风，中人多死。千般疾难，不越三条：一者，经络受邪，入脏腑为内所因也；二者，四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中也；三者，房室金刃，虫兽所伤，以凡详之，病由都尽。若人能养慎，不令邪风干忤经络，适中经络，未流传脏腑，即医治之，四肢才觉重滞，即导引吐纳，针灸膏摩，勿令九窍闭塞。更能无犯王法，禽兽灾伤，房室勿令竭之，服食节其冷、热、苦、酸、辛、甘，不遗形体有衰，病则无由入其腠理。腠者，是三焦通会元贞之处，为血气所注；理者，是皮肤脏腑之文理也。

【词解】

五常：即水火金木土的五行，五行上应天之五气，下应地之五味，中应人之五脏。

风气：狭义的风气，指春天的风气。广义的风气，指自然界的气候，本文当以后者为是。

元贞：应作“元真”，指五脏的元气和真气。

客气邪风：对主气而叫客气，对正气而叫邪气，总的指致病的不正常气候而言。

灾难：灾音趁。灾难即疾病。

导引吐纳：用意识引导呼吸吐故纳新的方法，而使五脏元真通畅。

膏摩：用药膏贴敷或以手按摩等外治之法。

服食：服，指衣服。食，指饮食。

【论解】

本条论述人与自然环境是一个统一的整体，“人禀五常”是说人禀五行之常，而其生长存活，则胥赖于风气。所以，“因风气而生长”这句话，指出了生命的条件离不开空气。空气，也就是风气。四时风气流行，适宜于自然界气候的要求，便能生长万物；若是不正常的自然气候，则能毒害万物，对人来说，就将变为一种致病因素。虽然如此，致病因素能否导致疾病的发生，还决定于人体的正气抗邪能力。只要五脏的元真之气充实，营卫通畅，抗病力强，就能适应反常气候，而不受邪气影响。反之，邪气病毒才能乘虚而入，侵害人的机体，甚至造成死亡。致病原因有三：一是正气已虚，经络受邪传入脏腑；二是正气未虚，客气邪风中于皮肤，传于血脉，使四肢九窍脉络，壅塞不通；三是由于房室过度，内损其精。另外，金刃、虫兽外伤其形，这是另一种致病因素，与上述的原因不同。

若人能内养正气，使得正气充实，风寒邪气不致侵犯经络。若有不慎，外邪中于经络，在其尚未内传脏腑之时，就及早治疗。比如邪中经络，四肢才觉重滞，即用导引、吐纳、针灸、膏摩等方法治疗，邪气不能内传，不使九窍闭塞不通。平时更要遵守国法，要避免禽兽灾伤，不要房室过度，耗损精液。饮食要寒热适中，不伤脾胃；五味不偏，营养得宜，使身体强壮，则使致病因素不能侵入腠理。什么是腠理？“腠”，是三焦通会元真之处；“理”，是皮肤、脏腑之纹理也。腠理有防御疾病的功能而为人之藩篱。

【选注】

《医宗金鉴》：“五常者，五行也。五行之气——风、暑、湿、燥、寒也；五行之味——酸、苦、甘、辛、咸也。夫人禀此而有其形，则藏府日与气味相通，不曰五气，而曰风气者，该他气而言也。盖风贯四气，犹仁贯四德，故曰：因风气而生长也。然风气虽能生万物，亦能害万物者，盖主气正风，从其所居之乡而来，主长养万物者也。客气邪风，从其冲后而来，主杀害万物者也。人在气交之中，其生其害，犹水

能浮舟亦能覆舟也。天之五气，人得之则为五藏真元之气，若通畅相生，虽有客气邪风，勿之能害，人自安和；如不通畅，则客气邪风，乘隙而入，中人多死……若人能慎养形气，不令客气邪风干忤经络，即适中经络，未传藏府，遂医治之，自可愈也。四肢九窍，才觉重滞，尚未闭塞，即导引、吐纳、针灸、按摩，亦可愈也。更能无犯王法，禽兽灾伤，房室勿令竭乏，服食节其冷热，五味各得其宜，不使形气有衰，万病疾难无由而入其腠理矣。腠者，一身气隙，血气往来之处，三焦通会真元之道路也。理者，皮肤藏府，内外井然，不乱之条理也。”

3.问曰：病人有气色见于面部，愿闻其说。师曰：鼻头色青，腹中痛，苦冷者死一云：腹中冷，苦痛者死。鼻头色微黑者，有水气；色黄者，胸上有寒；色白者，亡血也。设微赤非时者死。其目正圆者痉，不治。又色青为痛，色黑为劳，色赤为风，色黄者便难，色鲜明有留饮。

【诠解】

本条是论述上工望诊之法。医师通过观察患者的面部气色，可以判断疾病的部位和性质，因为精血藏于五脏，通过经络血脉而外荣于面。如果面部相应部位的光泽与颜色发生变化，则可反映五脏六腑的疾病。如鼻部内应于脾，鼻部出现青色，又见腹中痛的，则为肝邪乘脾；如再见腹中拘急疼痛而又苦冷的，则属脾阳衰败，寒凝水聚的重证。若鼻部色现微黑，水色为黑，此属肾阳衰弱，寒水凝聚不化之象，所以主水气之病。黄为土色，内应于脾，若面色黄暗，主脾气衰弱，谷精不能四布，水饮停于胸膈之间，所以主胸上有寒。若面色白者主亡血；如亡血之人，面色反见微赤，而时在冬令，则叫“非其时而有其色”，为阴阳两伤，虚阳外浮之色，故预后不良。还有失血更多，阴绝血亡，不能滋润眼睛和肌肉，先见两眼正圆，直视不瞑，如鱼目不闭，同时又发“痉”的，为肝阴内竭，证属不治。“色青为痛”，因青为血脉凝涩不通，所以青色主痛。“色黑为劳”，黑为水色，内应于肾，若肾精不足，阳衰不温，阴寒重布，所以黑色主肾劳之病。“色赤为风”，风为阳邪，多从火化，阳热上浮，故面赤主风。“色黄者便难”，面黄为脾虚不运，津液不布，不能滋润大肠，故主便难。“色鲜明者有留饮”，面色鲜明为水饮内停，溢于皮表，面部水肿，故见面部明亮光泽之色。

【选注】

《金匱要略心典》：“此气色之辨，所谓望而知之者也。鼻头，脾之部；青，肝之色；腹中痛者，土受木贼也；冷则阳亡而寒水助邪，故死。肾者主水，黑，水之色，脾负而肾气胜之，故有水气。色黄者，面

黄也，其病在脾，脾病则生饮，故胸上有寒。寒，寒饮也。色白，亦面白也，亡血者，不华于色，故白；血亡则阳不可更越，设微赤而非火令之时，其为虚阳上泛无疑，故死。目正圆者，阴之绝也；痉，为风强病，阴绝阳强，故不治。痛则血凝泣而不流，故色青。劳则伤肾，故色黑。经云：肾虚者，面如漆柴也。风为阳邪，故色赤。脾病则不运，故便难。色鲜明者，有留饮，经云：水病，人目下有卧蚕，面目鲜泽也。”

4.师曰：病人语声寂然，喜惊呼者，骨节间病；语声喑喑然不彻者，心膈间病；语声啾啾然细而长者，头中病一作痛。

【词解】

寂然：谓寂然不语，成语声低而不可闻。

喑喑然：指语声不响亮，而不清彻。

啾啾然：谓唧唧啾啾，语声小而悠长。

【诠解】

本条论述闻诊在临床上的应用。病人寒凝血滞于骨节，关节不利，安静不动则病轻，故语声寂然，若动而疼痛则喜惊呼；若痰湿浊邪壅塞心膈而气机不畅，故患者发声则喑喑然而不彻；若病人语声啾啾然小而悠长，为头中有病，因高声则震动头部，痛必愈甚，所以声不敢扬也。

【选注】

《金匱要略发微》：“无病之人，语声如平时，虽高下疾徐不同，决无特异之处。寒湿在骨节间，发为酸痛，故怠于语言而声寂寂，转侧则剧痛，故喜惊呼。心膈间为肺，湿痰阻于肺窍，故语声喑喑然不彻。头痛者，出言大则脑痛欲裂，故语声啾啾然细而长，不敢高声语也。”

5.师曰：息摇肩者，心中坚；息引胸中上气者咳；息张口短气者，肺痿唾沫。

【诠解】

本条是论从呼吸形态的变化来诊察疾病的方法。息指呼吸。呼吸而摇肩，是呼吸发生困难，故有抬肩举肋的状态。“心中坚”，指心胸中有邪气壅满而坚实，故使人喘也。若呼吸引胸中之气上逆而作咳，而为咳病，乃邪气阻肺之病；若呼吸张口短气的，乃上焦有热，肺叶枯萎，肺气不足。肺痿则津液不行，所以常吐涎沫。

【选注】

《金匱要略心典》：“心中坚者，气实而出入阻，故息则摇肩；咳者气逆而肺失降，则息引胸中上气。肺痿吐沫者，气伤而布息难，则张口短气，此因病而害于气者也。”

6.师曰：吸而微数，其病在中焦，实也，当下之即愈，虚者不治。在上焦者，其吸促；在下焦者，其吸远，此皆难治。呼吸动摇振振者，不治。

【诠解】

本条是从呼吸形态的不同，辨别病位之上下，以判断病势之轻重。吸而微数，是吸气短促，多由于中焦阻滞，气不得降，故吸而微数。若下其中实，则脾胃气利，呼吸自可恢复正常。若吸而微数，由于宗气衰竭，肾不纳气，为游息无根，则属不治。“在上焦者，其吸促”，指心肺宗气衰竭，气不得入则还，吸气浅而短。“在下焦者，其吸远”，指肝肾元气衰微，肾不纳气，气欲归而不骤及，则吸气长而远。在上焦和下焦的吸而微数乃正气不支之象，属于难治的证候。在呼吸时，全身动摇振振，为极端衰弱，形衰气弱，不能擎身之象，故曰不治。

【选注】

《金匱要略心典》：“息兼呼吸而言，吸则专言入气也。中焦实，则气之入者不得下行，故吸微数。数，犹促也。下之则实去气通而愈。若不系实而系虚，则为无根失守之气，顷将自散，故曰不治。或云：中焦实而元气虚者，既不任受攻下，而又不能自和，故不治，亦通。其实在上焦者，气不得入而辄还，则吸促，促，犹短也；实在下焦者，气欲归而不骤及，则吸远，远，犹长也，上下二病，并关脏气，非若中焦之实，可从下而去者，故曰难治。呼吸动摇振振者，气盛而形衰，不能居矣，故亦不治。”

7.师曰：寸口脉动者，因其王时而动，假令肝王色青，四时各随其色。肝色青而反色白，非其时色脉，皆当病。

【诠解】

本条是论述色、脉合于四时，而有当时和非时的不同。四时气候的变化，可以影响人体五脏的生理变化，从而面部的气色和寸口的脉象也有变化。如在春季，气候温和，一阳之气上升，为木气当令之时，故脉弦而面色青；盛夏气候炎热，火气当令之时，故脉来洪而面色赤；秋季气候凉燥，金气当令之时，故脉浮而面色白；冬季气候寒冷，水气当令之时，故脉沉而面色黑，此为应时五脏之正常色脉。假如春令而面色反白，脉反浮涩而短，是春令反见秋之色脉，而为异常表现，这是属于异

常的病理反映，故曰：“非其时色脉皆当病。”

【选注】

《医宗金鉴》：“寸口者，统言左右三部脉也。脉动法乎四时，命乎五藏，然必因其王时而动，则为平脉也。假令肝旺于春，随其时，色当青，脉当弦，此不病之色脉也。若色反白，脉反浮，此非其时，乃病之色脉也。四时准此。”

8.问曰：有未至而至，有至而不至，有至而不去，有至而太过，何谓也？师曰：冬至之后，甲子夜半少阳起，少阳之时阳始生，天得温和。以未得甲子，天因温和，此为未至而至也；以得甲子而天未温和，为至而不至也；以得甲子而天大寒不解，此为至而不去也；以得甲子而天温如盛夏五六月时，此为至而太过也。

【词解】

未至而至：时令未至，而气候已至。前“至”字指时令，后“至”字指气候。

甲子：指冬至之后，经过六十天的第一个甲子日。

少阳之时：三阴三阳各旺六十日，共三百六十日。冬至之后，正是少阳当令之时。

【论解】

本条指出气候与节气应该相适应，气候的太过或不及，都会影响人体而发生疾病。一年有二十四个节气，每个节气的气候各不相同。冬至之后的雨水节（即第一个甲子日的夜半），正是少阳当令的时候，阳气开始生长，气候转为温和，这是正常的气候规律。如未到雨水节，而气候已转温和，此为未至而至，是时令未到，气候先到；如已至雨水节，而气候未转温和，此为至而不至，是时令已到，气候未到。如已至雨水节，气候仍然很冷，此为至而不去，是时令已至雨水节，而寒冬之气犹然不去；如已至雨水节，气候变得太热如盛夏之时，此为至而太过，是时令已超过雨水节，则为至而太过。总之，凡是气候先至、不至、不去、太过皆属异常之气候，都会影响人体的气血而发生疾病。

【选注】

《金匱要略心典》：“云少阳起者，阳方起而出地；阳始生者，阳始盛而生物，非冬至一阳初生之谓也，窃尝论之矣。夏至一阴生，而后有小暑、大暑；冬至一阳生，而后有小寒、大寒，非阴生而反热，阳生而反寒也。天地之道，否不极则不泰；阴阳之气，剥不极则不复。夏至

六阴尽于地上，而后一阴生于地下，是阴生之时，正阳极之时也；冬至六阳尽于地上，而后一阳生于地下，是阳生之时，正阴极之时也。阳极而大热，阴极而大寒，自然之道也，则所谓阳始生天得温和者，其不得与冬至阳生同论也，审矣。至未得甲子而天已温，或已得甲子而天反未温，及已得甲子而天大寒不解，或如盛夏五六月时，则气之有盈有缩，为候之或后或先，而人在气交之中者，往往因之而病，惟至人为能与时消息而无忤耳！”

9.师曰：病人脉浮者在前，其病在表；浮者在后，其病在里。腰痛背强不能行，必短气而极也。

【诠解】

本条举例说明同一脉象，出现的部位不同，主病也就不同。“病人脉浮者在前”，指浮在寸口，这是正气向外，抗病于表的现象。如外感表证，寸口脉浮而有力，又伴有恶寒发热，头疼身痛等表证。“浮者在后”，指浮在尺部，这是肾阴不足，虚阳外浮的现象。阴虚而阳张，脉浮而必无力，又伴有肾亏骨弱引起的腰疼背强，骨痿行走无力，以及肾不纳气引起的呼吸气短而甚等证候。总之，脉浮为气血向上向外之势，有外感表证和内伤虚证的不同，必须认清浮脉的部位、强弱以及其他症状，才能认识疾病的本质。

【选注】

《金匱要略心典》：“前，谓关前，后，谓关后；关前为阳，关后为阴，关前脉浮者，以阳居阳，故病在表；关后脉浮者，以阳居阴，故病在里，然虽在里而系阳脉，则为表之里，而非里之里，故其病不在肠肾，而在腰背膝胫，而及其至，则必短气而极。所以然者，形伤不去，穷必及气；表病不除，久必归里也。”

10.问曰：经云：厥阳独行，何谓也？师曰：此为有阳无阴，故称厥阳。

【诠解】

本条是论述厥阳的病机。“厥阳独行”，指人体肝肾之阴血枯竭，而阳气失去依附，则阳气偏胜。有阳无阴，有升无降，故厥阳独行，症见面赤眩晕、神昏不语等。

【选注】

《医宗金鉴》：“阴阳偕行，顺也；阴阳独行，逆也。厥，逆也，逆阳独行，此为有阳无阴，故称厥阳也。”

11.问曰；寸脉沉大而滑，沉则为实，滑则为气。实气相搏，血气入脏即死，入腑即愈，此为卒厥。何谓也？师曰：唇口青，身冷，为入脏即死；如身和，汗自出，为入腑即愈。

【词解】

卒厥：突然昏倒。

【诠解】

本条举“卒厥”证为例，说明疾病传变的规律，预断疾病发展的方法。两手的寸部脉沉大而滑，沉大为里实，滑为痰气郁滞。若邪随血气内入于心，血瘀气滞而不流通，则神去机息，故唇口青，身冷，忽然昏倒而死。若邪气入腑，则传而不藏，气还血行，阳气外达，则身和，汗自出，故愈。

【选注】

《金匱要略编注》：“邪气入脏，神明昏愤，卒倒无知，谓之卒厥。若唇口青身冷，即是邪气入脏，堵塞血气，神机不能出入，脏气垂绝，所以主死；若身和汗出，乃邪气入腑，闭塞腑气，不得出入，一时卒倒，非脏绝之比，顷时阳气外达，邪气随之外泄，故知入腑即愈。”

12.问曰：脉脱入脏即死，入腑即愈，何谓也？师曰：非为一病，百病皆然。譬如浸淫疮，从口起流向四肢者，可治；从四肢流来入口者，不可治；病在外者，可治；入里者，即死。

【词解】

脉脱：邪气乍加，气血不通，脉绝似脱。

浸淫疮：指皮肤之黄水疮，能从局部波及全身。

【诠解】

本条举例论述疾病传变有顺逆的不同。“脉脱”为正邪相争，邪气逼于经脉，正气被遏，经脉不通，故脉绝似脱。若邪气入脏者，则深而难出，故气竭不复则死；邪气入腑者，浅而易通，故气行脉出即愈。

浸淫疮为湿热火毒之邪浸淫肌表，发为皮肤湿疮。若正气衰弱，从四肢流来入口者，为毒邪从外入里，故不可治；若从口而流向四肢者，则为毒邪从里达表，故为可治。总之，病由外传内者难治，由内传外者易治。这是诊断疾病的普遍规律，所以说：“非为一病，百病皆然。”

【选注】

《金匱要略正义》：“脏为阴，腑为阳，阴主里，阳主外。凡病以

出阳为浅，入阴为深，故即死、即愈之机所由别也。浸淫疮显而易见，可知非独卒中为然，内外百病，皆作如是论治耳。”

13.问曰：阳病十八何谓也？师曰：头痛，项、腰、脊、臂、脚掣痛。阴病十八何谓也？师曰：咳，上气，喘，哕，咽，肠鸣胀满，心痛拘急。五脏病各有十八，合为九十病；人又有六微，微有十八病，合为一百八病，五劳、七伤、六极、妇人三十六病，不在其中。清邪居上，浊邪居下，大邪中表，小邪中里，**榮**飪之邪，从口入者，宿食也。五邪中人，各有法度，风中于前，寒中于暮，湿伤于下，雾伤于上，风令脉浮，寒令脉急，雾伤皮腠，湿流关节，食伤脾胃，极寒伤经，极热伤络。

【词解】

飪：音拖。即饂飪，是属于汤饼一类的食物。

【诠解】

本条是论述病症的分类方法，以及邪气伤人的规律。阳病是指外表经络的病证，包括头、项、腰、脊、臂、脚等六个部位，每个部位又有营病、卫病、营卫交病三种性质，三乘六得一十八，故曰阳病十八。阴病是指内部脏腑的病证，包括咳、上气、喘、哕、咽、肠鸣、胀满、心痛、拘急等九种病，每个病又分虚病、实病两种，二乘九得一十八，故曰阴病十八。五脏病各有十八，合为九十病，谓五脏受风寒暑湿燥火六淫之邪而为病，有在气分、血分、气血兼病三者之别，三乘六为五脏各有十八病，十八乘五为九十病。“六微”指六腑病，有六淫之邪中于六腑，又有气分、血分以及气血兼病三者之别，三乘六为微有十八病，综上所述，六个十八，合为一百零八病。五劳，为五脏劳伤之病，如久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋；又指心劳、肺劳、脾劳、肾劳、肝劳，叫五脏劳伤。七伤，即食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤。六极（极，是极度劳损的意思），即气极、血极、筋极、骨极、肌极、精极。妇人三十六病，据《千金》所载，为十二癥、九痛、七害、五伤、三瘕等，均是妇科杂病。“清邪居上”，“雾伤于上”，“雾伤皮腠”，谓雾露轻清之邪，伤于上部皮腠为病。“浊邪居下”，“湿伤于下”，“湿流关节”，谓水湿重浊之邪，伤于下部流入关节为病。“大邪中表”，“风中于前”，“风令脉浮”，谓风为阳邪，午前伤人，引起伤风，脉浮缓等表证。“小邪中里”，“寒中于暮”，“寒令脉急”，谓寒为阴邪，旦暮伤人，引起寒邪外中，脉紧急等表证。“**榮**飪之邪，从口入者，宿食也”，谓饮食不节，则伤脾胃，引起腹痛胀满等证。“极寒伤经”，谓寒邪归于阴经而主静，引起经脉不通，

疼痛等证。“极热伤络”，谓热邪入于脉络主动，引起脉络血奔、出血等证。“五邪中人，各有法度”，谓所伤之部位、受伤之时间、所表现之脉证，都有一定的客观规律性。

【选注】

《医宗金鉴》：“头痛、项、腰、脊、臂、脚掣痛，病皆在外，故为阳病也；咳、上气、喘、哕、咽、肠鸣、胀满、心痛、拘急，病皆在内，故为阴病也。清邪居上，谓雾邪本乎天也；浊邪居下，谓湿邪本乎地也。六淫天邪，故名大邪，六淫伤外，故曰：中表也；七情人邪，故名小邪，七情伤内，故曰：中里也。榮飧者，饮食也。饮食之邪，从口而入，食伤隔夜不化，故名曰：宿食也。五邪，谓风、寒、湿、雾、饮食也。夫五邪之中人，莫不各以类而相从。前者早也，风中于早，从阳类也。寒中于暮，从阴类也。雾邪清轻，故伤皮肤。湿邪浊重，故流关节。饮食失节，故伤脾胃。极寒之食伤经，以经属阴也；极热之食伤络，以络属阳也。”

14.问曰：病有急当救里、救表者，何谓也？师曰：病，医下之，续得下利清谷不止，身体疼痛者，急当救里，后身体疼痛，清便自调者，急当救表也。

【诠解】

本条是论述表里同病，急则先治的原则。病，而医误下之，损伤脾胃，续发下利清谷不止，此时虽有身体疼痛等表证不解，也要急当救里。因为下利清谷不止，则阳气虚惫可知，故急当救里，宜四逆汤。如服药后，大便调和，脾胃恢复正常，此时则应急当救表，以免表邪传里，宜桂枝汤。前者先救里，在于护正为急，后者急当救表，则在于祛邪以杜其传也。

【选注】

《金匱要略心典》：“治实症者，以逐邪为急；治虚症者，以养正为急。盖正气不固，则无以御邪而却疾；故虽身体疼痛，而急当救里。表邪不去，势必入里而增患，故即清便自调，则仍当救表也。”

15.夫病痼疾，加以卒病，当先治其卒病，后乃治其痼疾也。

【诠解】

本条是论述久病新病同时存在，要以先治新病为原则。痼疾是难治的久病，病势已经缓和，治已不易，更难除根，不能急治；卒病是新得之病，病势急迫，变化多端，但是容易治愈，故以先治为妙。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“痼疾，谓病已沉痼，非旦夕可取效者。卒病，谓卒然而来，新感而可取效于旦夕者，乘其所入未深，急去其邪，不使稽留而为患也。且痼疾之人，正气素虚，邪尤易传，设多瞻顾，致令两邪相合，为患不浅。故仲景立言于此，使后之学者，知所先后也。”

16.师曰：五脏病各有得者愈；五脏病各有所恶，各随其所不喜者为病。病者素不应食，而反暴思之，必发热也。

【词解】

有得：指五脏得其所宜之气、之味、之时，则以助脏气而祛病。

所恶：指五脏所厌恶之气。如心恶热，肺恶寒，肝恶风，脾恶湿，肾恶燥。

所不喜：指五脏之所禁，如心病禁温食热衣；脾病禁温食饱食，湿地濡衣；肺病禁寒饮，寒衣；肾病禁热食，温灸。

【诠解】

本条是论述护理原则。五脏疾病的性质是不同的，因而适应病情的饮食居处也是不同的。病人的所得、所恶、所不喜，要随疾病的性质不同而变化。如病人脾胃虚寒，适合病人的饮食是以热熟易消化的食物为好，温暖的居处，又服温补脾胃的药物，则脾胃虚寒能够治愈。反之，给病人以生冷黏滑不易消化的食物，寒冷潮湿不良的居处，加以苦寒伤胃气的药物，有此所恶和所不喜则使疾病有异常变化，医生亦不可不注意。如病人素不应食，而突然反暴思之，是乃病邪之气，变其脏气使然，故食之则适以助病气而增发热。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“五脏病各有所得，如其喜者而与之，能助其正而息其邪，其病可愈也；五脏病又各有所恶，各随其所不喜者而为病，犯其所忌而与之，能伤其正而益其邪，其病必增也。此病之性情，亦因人之性情为性情，而人之性情各有嗜好，百事皆然，食物又易于观辨。病者素不应食者，不喜食之物也，因病而复暴思欲食，此病为饥渴所以害之也，因与食之，其脏与之不相宜，食之必发热，无益于气血，而徒长其病邪。可见所喜者应与之，而所恶者应远远之理矣。”

17.夫诸病在藏欲攻之，当随其所得而攻之，如渴者与猪苓汤，余皆仿此。

【词解】

所得：指无形之邪，入结于脏必有所得之物。

【诠解】

本条是举例说明随其所得而攻之的道理。病在脏腑，如水、血、痰、食之实邪皆可攻下以去，然当随其所得之邪，如渴者，水与热得，而热结在水，故用猪苓汤利其水而热亦除矣。

【选注】

《金匱要略心典》：“无形之邪，入结于脏，必有所据，水、血、痰、食，皆邪藪也。如渴者，水与热得，而热结在水，故与猪苓汤利其水，而热亦除；若有食者，食与热得，而热结在食，则宜承气汤下其食，而热亦去，若无所得，则无形之邪，岂攻法所能去哉。”

结语

本篇是论述疾病的预防、病因、病机、诊断以及治疗等内容。首先提出的重要治略思想就是“治未病”。治未病的关键，是要掌握疾病相传的规律，如能掌握这一规律，就可以控制病势的传变。另外，也要掌握治疗虚证的“补”、“助”、“调”三个方法，和“补不足，损有余”的治病大法。

本篇科学的论述：构成生命的基本元素是五常，生命存在的条件是风气。因此说，人与自然息息相关。不正常的气候，能影响人体而发生疾病，关键还决定于正气的强弱。如五脏元真通畅，人既安和，病则无由入其腠理。关于病因分类方面，也有内生、外中和其他方面。

本篇还论述了诊断疾病、预防疾病和护理原则等内容。

本篇在治疗方面，提出了表里同病，治疗原则是急者先治；久病、新病同时存在，原则是先治新病；以及“随其所得而攻之”的灵活的辨证论治思想。

本篇条文虽不多，但都是一些原则性的提示，这在全书中具有纲领性的意义。

痉湿喝病脉证第二

概说

本篇是论述痉、湿、喝三病的辨证论治。篇中共有条文二十七条，载方十一首。其中第一条至第十条为痉病的总论，说明了痉病的病因、病理、脉证、分类以及治疗原则和转归。第十一、十二、十三条则为痉病的各论，对痉病的辨证论治进行了阐述。第十四条至第十九条乃是湿病的总论，说明了湿病的病因、病理与症状，以及治疗原则和转归；第二十至二十四条则为湿病的各论，对湿病的辨证论治进行了阐述。第二十五、二十六、二十七条阐述喝病的脉证、治疗法则和方证。由于痉、湿、喝三病，均为感受风寒暑湿之邪而与太阳表证有关，故合为一篇加以论述。

痉病是以项背强急，口噤不开，甚至角弓反张为主证的病证；湿病是以关节不利，身体肿痛为主证的病证；喝，又名伤暑，而以发热恶寒，口渴身疼为主证的病证。

1.太阳病，发热无汗，反恶寒者，名曰刚痉一作痉，余同。

【诠解】

本条是论述刚痉的辨证。“刚痉”由太阳中风重感于寒，外寒闭塞营卫，故出现恶寒、无汗、头疼、发热、脉浮而紧等证。风寒之邪滞郁经脉，经脉气血不利，则出现筋脉紧急的项背强急，口噤不开等证。因其无汗，故称“刚痉”。考《甲乙经·卷七》无“反”字为是。

【选注】

《注解伤寒论》：“《千金》曰：太阳中风，重感寒湿则变痉。太阳病，发热无汗为表实，则不当恶寒，今反恶寒者，则太阳中风，重感于寒，为痉病也。以表实感寒，故名刚痉。”

2.太阳病，发热汗出，而不恶寒，名曰柔痉。

【诠解】

本条是论述柔痉的辨证。“柔痉”由太阳中风，风邪化热，热伤血脉，筋无所荣，故颈项强急，甚则反张。太阳中风，卫强荣弱，正邪相争，表气不固，出现发热，汗出，头疼，而不恶寒，脉浮缓等证。刚、柔二痉的区别，“刚痉”为表实无汗，“柔痉”为表虚有汗。外感风寒引起痉病，一方面为风寒邪气客于太阳经脉，另一方面为平素阴血虚少，感邪之后容易化燥伤阴，阴血不濡，筋脉拘急则成痉。

【选注】

《注解伤寒论》：“太阳病，发热汗出为表虚，则当恶寒，其不恶寒者为阳明病。今发热汗出而不恶寒者，非阳明证，则是太阳中风，重感于湿，为柔痉也。表虚感湿，故曰柔痉。”

3.太阳病，发热，脉沉而细者，名曰痉，为难治。

【诠解】

本条是论述痉病的预后。太阳病为表证，表证则发热，其脉浮，方为应病。今脉沉而细，是太阳证而见少阴之脉。此时，如见项背强直的证候则名曰痉。因正虚不能胜邪，故为难治。何哉？此证若发散在表之邪气，可损伤少阴精血；若补养精血之虚，又恐碍太阳之表，而恐有留邪之弊。

【选注】

《医门棒喝·伤寒论本旨》：“太阳伤风寒，其脉浮，以邪浅在营卫也。痉病邪深伤筋，故脉沉紧弦，直上下行也；其不紧弦而沉细，则邪入深，而气血大虚，正不胜邪，邪何能出，故为难治。”

4.太阳病，发汗太多，因致痉。

【诠解】

本条是论述误汗成痉。太阳病，属于表证，应发汗解表，而以微似汗出者为得法。若太阳病发汗太多，则必耗伤阴血，阴血先虚，不能濡养筋脉，则可发生项背强直的痉病。

【选注】

《医宗金鉴》：“太阳病当发汗，若发汗太过，腠理大开，表气不固，邪风乘虚而入，因成痉者，乃内虚所召入也，宜以桂枝加附子汤主之，固表温经也。由此推之，凡病出汗过多新产，金疮破伤出血过多，而变生此证者，皆其类也。”

5.夫风病下之则痉，复发汗必拘急。

【论解】

本条是论述误下成痉。因外感风邪，入里化热，热蒸汗出，津液已伤，又误下伤阴，营血更弱，不能濡养筋脉，则使筋脉拘急，形成痉病。复发汗，更伤阴血阳气，阴阳两虚，则更不能温润，引起四肢筋脉拘挛强急而成痉。

【选注】

《医宗金鉴》：“因风邪为病，不应下而下之伤液，不应汗而汗之伤津，以致津液枯燥，筋失所养而病痉者，故曰：风病下之则痉，复发汗必拘急。此不可以外感痉病治之，当以专养津液为务也。”

6.疮家虽身疼痛，不可发汗，汗出则痉。

【论解】

本条是论述久患疮疡的病人气血已伤，而误汗成痉之理。患疮疡的病人，虽有表证，亦不可发汗解表。因为疮家津血已经亏损，此时虽有身体疼痛的表证，为伤寒挟虚，故不能发汗。如发汗解表，则重伤津液，筋脉失去津血的濡养，因而发生痉病。

【选注】

《医宗金鉴》：“疮家初起，毒热未成，法当汗散。已经溃后，血气被伤，虽有身痛表证，亦不可发汗，恐汗出血液愈竭，筋失所养，因而成痉，或邪风乘之，亦令痉也。”

7.病者，身热足寒，颈项强急，恶寒，时头热，面赤目赤，独头动摇，卒口噤，背反张者，痉病也。若发其汗者，寒湿相得，其表益虚，即恶寒甚。

【论解】

本条论痉病的主证及汗后的脉证反映。痉病不离乎表，故身热恶寒。痉为风强病，而筋脉受之，故口噤，头项强，背反张而筋脉拘急。

《内经》说：“诸暴强直，皆属于风”，故头热、足寒、面目赤、头动摇，反映了风阳上行而又掉动，此痉病之主证，不可不知也。此证若发其汗，汗沾衣被变化为湿，又与外寒之气，相搏不解，则卫阳以汗出而益虚，寒邪得湿而转增，故恶寒为甚。

【选注】

《金匱要略直解》：“身热头热，邪在太阳也；面赤目赤，邪在阳明也。颈属阳明，项属太阳，邪在二经，则颈项强急恶寒也。阳明之脉挟口，故卒口噤；太阳之脉循背上头，故头独摇，背反张也。此其人必

汗下亡血之后，正气已虚，而邪气但胜于上，其足则寒，此痉病之证俱见也。”

8.发其汗已，其脉如蛇一云：其脉淅淅。暴腹胀大者，为欲解，脉如故；反伏弦者痉。

【诠解】

本条继上文言痉脉本直，汗后则风解而湿仍存，故脉不直而曲如蛇行之状。魏荔彤云：“风去不与湿相丽，则湿邪无所依著，必顺其下坠之性，而入腹作胀矣。风寒外解，而湿下行，所以为欲解也。如是诊之，其脉必浮而不沉，缓而不弦矣。乃其脉如故，而反加伏弦，知其邪内连太阴，里病转增，而表病不除，乃痉病诸证中之一变也。”

【选注】

《医宗金鉴》：“发寒湿汗后，其脉不直紧，如蛇之曲缓，则为邪退，不成痉病，为欲解也。若脉仍直紧不缓，或不直紧反伏坚弦急者，为邪不退，成痉病矣。”

9.夫痉脉，按之紧如弦，直上下行一作：筑筑而弦。《脉经》云：痉家其脉伏坚，直上下。

【诠解】

本条是论述痉病的主脉。痉病是重感风寒湿邪，邪气外束，筋脉强急，气血由内向外而抵抗有力，故见脉弦紧劲急，直上下行。

【选注】

《金匱要略心典》：“紧如弦，即坚直之象。李氏曰：上下行者，自寸至尺，皆见紧直之脉也。《脉经》亦云：痉病脉坚伏，直上下行。”

10.痉病有灸疮，难治。

【诠解】

本条是论述痉病有灸疮的预后情况。病人灸后成疮，一则流失脓液，津血已经亏损，二则火热内盛，经穴不闭，再感风寒，成为痉病。本病若用发汗解表，又恐热伤阴血，更助风燥；若用泻下实热之法，更虑内伤阴液，汗下皆不可为，故曰难治。

【选注】

《金匱要略心典》：“有灸疮者，脓血久渍，穴俞不闭，楼全善云：即破伤风之意。盖阴伤而不胜风热，阳伤而不任攻伐也。故曰难

治。”

11.太阳病，其证备，身体强，**几几**然，脉反沉迟，此为痉。栝楼桂枝汤主之。

栝楼桂枝汤方

栝楼根二两 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚

上六味，以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗。汗不出，食顷啖热粥发。

【词解】

几几然：背强连颈，拘急不伸之状。

【诠解】

本条是论述痉病的辨证论治。太阳病，其证备，指太阳之脉，自足上行，循背至头顶，凡所过之处，而为拘紧强急以成痉。如风邪居表，则脉必浮数。此证虽身体强**几几**，而脉反沉迟，沉迟之脉，乃津液不足而荣卫不利，故筋脉失于濡润，是以作痉。

治用栝楼桂枝汤。方中栝楼根清热生津，柔润筋脉，通行经气；桂枝利卫通阳，芍药和营敛阴；甘草、生姜、大枣则能健脾气，和营卫，使经气流畅，筋燥得润，而痉病自愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“沉本痉之脉，迟非内寒，乃津液少而营卫之行不利也。伤寒项背强**几几**，汗出恶风者，脉必浮数，为邪风盛于表；此证身体强**几几**然，脉反沉迟者，为风淫于外而津伤于内，故用桂枝则同，而一加葛根以助其散，一加栝楼根兼滋其内，则不同也。”

12.太阳病，无汗，而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两 麻黄三两，去节 桂二两，去皮 芍药二两 甘草二两，炙 生姜三两 大枣十二枚

上七味，**咬**咀，以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，复取微似汗，不须啜粥。余如桂枝汤法将息及禁忌。

【诠解】

本条是论述刚痉的辨证论治。刚痉是重感风寒湿邪，卫阳闭郁，营阴郁滞，正邪交争，故见发热、恶寒、无汗、头疼、身疼、脉浮紧等证。太阳病无汗，湿邪闭郁胸中，气机不得通利，故小便反少。里气既不能外达，又不能下行，势必逆上冲胸，故胸满。湿热闭郁胸中，损伤津液，不能滋润筋脉，故口噤不得语。如斯则可知刚痉即将发作。

治以葛根汤开泄腠理，发汗祛邪，滋养津液，舒缓筋脉。方中葛根能透达表邪，启胃气而生津液，滋润筋脉，舒缓强急；麻黄配桂枝、生姜外散风寒，以开玄府之闭塞；芍药、甘草、大枣和营生津，以缓拘急。

【选注】

《金匱要略心典》：“无汗而小便反少者，风寒湿甚，与气相持，不得外达，亦并不下行也。不外达，不下行，势必逆而上冲，为胸满，为口噤不得语，驯至面赤头摇，项背强直，所不待言，故曰欲作刚痉。葛根汤，即桂枝汤加麻黄、葛根，乃刚痉无汗者之正法也。”

【病案举例】

张某，13岁。1977年9月13日初诊：起初偶有外感症状，身体不适，两天后猝然抽搐，先口噤，继而项背强急，角弓反张，无汗，神清，自觉憋气，困倦酸重，舌苔薄白，脉紧数。检查：体温37.5℃，血压：110/70毫米汞柱，生理反射正常，无病理反射。化验血象：白细胞15200/立方毫米。诊断：刚痉，由风寒壅阻脉络，气血滞阻，故筋脉挛急，项背强直，治以祛风散寒，解肌和营。

处方：葛根1.0克，麻黄3.0克，桂枝5.0克，白芍12.0克，天花粉12.0克，甘草3.0克，生姜3片，大枣4枚（擘），送服解痉散3.0克（全蝎、蜈蚣等分，共研细末，每服1.5~3克），覆被取汗。

复诊：服药一剂，遍身**赳赳**微似有汗，痉止，嘱其再进一剂而愈。

（摘自《江苏医药》（中医分册）1979,1:24）

13.痙为病一本痙字上有刚字，胸满口噤，卧不着席，脚挛急，必^𪔐齿，可与大承气汤。

大承气汤方

大黄四两，酒洗 厚朴半斤，炙，去皮 枳实五枚，炙 芒硝二合

上四味，以水一斗，先煮二物取五升，去滓，内大黄煮取二升，去滓；内芒硝，更上火微一二沸，分温再服，得下止服。

【词解】

^𪔐齿：^𪔐，音械，齿相切，俗叫咬牙。

【诠解】

本条是论述实热痙的辨证施治。肠胃实热积滞，壅盛郁塞，所以胸腹胀满。燥热劫烁津液，不能濡养筋脉，筋脉强急，故角弓反张，卧不着席，四肢挛急。阳明热盛，变燥化风，掣动筋脉，故口噤，^𪔐齿。

本证为痙病实热重证，可与大承气汤，急下存阴，通腑泄热。方中大黄、芒硝泄其实热；枳实、厚朴破其壅塞。本方峻泻肠胃实热积滞，则阴可复，而津液可存，痙强之证可以缓解。

【选注】

《医宗金鉴》：“此申痙病入里，以明其治也。痙病而更胸满，里气壅也；卧不着席，反张甚也；脚挛急，劲急甚也；必^𪔐齿，牙紧甚也。此皆阳明热盛灼筋，筋急而甚之象，故以大承气汤直攻其热，非攻阳明之实也。其曰可与，非尽言其可与，有慎重之意。”

【病案举例】

某医院一破伤风患儿，病起迄四日，曾用祛风镇痙之玉真散，不效，邀余会诊。热不退，便不通，痙不止，舌燥苔黄，脉见数实。证属热结阳明，热极生风，法当下。即予大承气汤：大黄15克（后下），芒硝12克（冲），厚朴24克，枳实12克。越日再诊，证情未减。硝黄当显效，何迟迟未下？心疑不解！询知乃病家恐前方过峻，自行减半以进。由于病重药轻，服后便结如故，当此风热正盛，燥结如石，非借将军之力下之不为功。遂照方急煎迭进，药后四五个小时，肠中漉漉，先排出石硬色黑如鸡卵大粪块，随下秽物半便盆，如鼓之腹得平，再剂又畅行

三次，痉止身凉，病瘥。继用养血舒肝剂调理巩固。

（摘自《新中医》1980,6:47）

14.太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细一作缓者，此名湿痹《玉函》云：中湿。湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便。

【词解】

疼痛而烦：烦，疼得很重的意思。

【诠解】

本条是论述湿痹的证治原则。湿邪伤于太阳之表，而见一身关节烦疼；若脉浮细者，为湿在于外，应当用汗解之。若其人小便不利，而大便反痛快，脉又沉细者，病名叫“湿痹”，湿痹忌汗，而应利其小便，以使湿邪得去。

【选注】

《医门法律》：“湿流关节之痛，脉见沉细者，则非有外风与之相搏，只名湿痹。湿痹者，湿邪痹其身中之阳气也。利其小便，则阳气通行无碍，而关节之痹并解矣。”

15.湿家之为病，一身尽疼一云：疼烦，发热，身色如熏黄也。

【诠解】

本条是论湿郁发黄的辨证。湿家之为病：湿盛于外者，阳必郁于内，湿盛于外，则一身尽疼，阳郁于内，则发热，湿热郁于肌肉之间，则身色如烟之熏黄而带黑。

【选注】

《医宗金鉴》：“湿家，谓病湿之人。湿之为病，或因外受湿气，则一身尽痛；或因内生湿病，则发热身黄。若内外同病，则一身尽痛，发热，身色如熏黄也。湿家之身痛发黄，不似伤寒之身痛发黄者，以无六经之形证也。”

16.湿家，其人但头汗出，背强，欲得被复向火，若下之早则哕。或胸满，小便不利一云利，舌上如胎者，以丹田有热，胸上有寒，渴欲得饮而不能饮，则口燥烦也。

【诠解】

本条是论述湿家误下的变证。湿家头汗出，为上有湿下有热，蒸而使然，非阳明内实之热，蒸而上越之比。背强者，乃湿家重着之强，非风寒拘急之强。欲复被向火，乃湿盛伤阳，阳受伤则恶寒。此证如误以

阳旺内热上越之头汗而误下之，则湿从寒化，如寒邪入于肺，则胸满；寒邪入于胃，则为哕；寒邪入于膀胱，则气化不行，而小便不利。至于舌上白滑之苔，乃误下而热陷于下，寒聚于上之故。胸中有寒，则不欲饮，下有热，而口中干燥，此乃为津液不化之咎。

【选注】

《金匱要略心典》：“寒湿居表，阳气不得外通而但上越，为头汗出，为背强，欲得被覆向火，是宜驱寒湿，以通其阳。乃反下之，则阳更被抑，而哕乃作矣；或上焦之阳不布，而胸中满；或下焦之阳不化，而小便不利，随其所伤之处而为病也。舌上如胎者，本非胃热，而舌上津液燥聚如胎之状，实非胎也。盖下后阳气反陷于下，而寒湿仍聚于上，于是丹田有热而渴，欲得饮，胸上有寒而复不能饮，则口舌燥烦而津液乃聚耳。”

17.湿家，下之，额上汗出，微喘，小便利一云不利者死；若下利不止者亦死。

【论解】

本条亦论湿家误下的死证。湿家误下变证百出，至其甚者，而又有死证，医者亦不可不知。湿家如邪在表当发汗，邪在里当利小便，苟非湿热蕴结成实，则未可用之。如误用，则无的放矢，必先伤正气，额上汗出微喘，乃重伤阳气，孤阳上越，故额上汗出而微喘；若脾阳大伤，清阳不升，则下利不止，此乃阴阳离决之象，其预后不抱乐观。若其人小便利者，而见于下后额汗而喘，反映了阳离而上行，阴孤而下走，故亦主死。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“此总言湿证无下法也。上节言误下变证，为寒热郁结，此节言误下伤肾，则小便自利气喘而死。误下伤脾，则大便下利不止而死。观仲景方，皆是补土以治湿，则知湿家断无下法也。”

18.风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解，值天阴雨不止，医云：此可发汗。汗之病不愈者，何也？盖发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。

【词解】

似欲出汗：似，当续字解，微续汗出之意。

【诠解】

本条是论述风湿病的治疗原则。外感风湿，困于肌肤，流走关节，气血运行不畅，故一身疼痛。此证当以汗法而散风湿之邪，则其病可愈。假如正值天气阴雨不止，湿气较盛之时，则发汗法便无效，为什么？由于天气阴雨不止，天、人之湿必重。风为阳邪，容易表散，而湿为阴邪，难以骤除，故发汗风气虽去而湿邪仍在，其病不愈。治风湿之法，应该温阳解表，使阳气伸展，营卫流行，微似汗出，则散漫黏滞之邪，方能缓缓排出体外。

【选注】

《医门棒喝·伤寒论本旨》：“若治风湿者，必通其阳气，调其营卫，和其经络，使阴阳表里之气周流，则其内湿随三焦气化，由小便而去，表湿随营卫流行，化微汗而解，阴湿之邪既解，风邪未有不去者，此治风湿与治风寒不同者。虽寒湿同为阴邪，而寒清湿浊，清者易散，浊者粘滞，故发汗大有区别也。”

19.湿家病，身疼发热，面黄而喘，头痛鼻塞而烦，其脉大，自能饮食，腹中和无病，病在头中寒湿，故鼻塞，内药鼻中则愈《脉经》云：病人喘。而无“湿家病”以下至“而喘”十三字。

【词解】

内药：内，读纳。

【诠解】

本条是论述头中寒湿的证治。雾露之湿为清邪，伤于身半之上，湿邪外束，故头疼、鼻塞、上半身疼。寒湿外束，肺气上逆则喘；湿邪弥漫，扰于心中，故发心烦；其人面黄而身不黄，为湿在上之候。正邪相争，阳气向外，故发热，脉大。腹中和为无病，故自能饮食，可知湿邪此时并未传里。治宜宣散寒湿，通利气机。如用瓜蒂为细末，搐鼻流出黄水，可使阳气宣利，透出在上寒湿，则诸证可愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“寒湿在上，则清阳被郁。身疼、头痛、鼻塞者，湿上甚也；发热、面黄、烦、喘者，阳上郁也；而脉大，则非沉细之比；腹和无病，则非小便不利，大便反快之比，是其病不在腹中而在头。疗之者宜但治其头而毋犯其腹。纳药鼻中，如瓜蒂散之属，使黄水出则寒湿去而愈，不必服药以伤其和也。”

20.湿家，身烦疼，可与麻黄加术汤发其汗为宜，慎不可以火攻之。

麻黄加术汤方

麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮 甘草一两，炙 杏仁七十个，去皮尖 白术四两

上五味，以水九升先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药煮取二升半，去滓，温服八合，复取微似汗。

【诠解】

本条是论述寒湿在表的证治。平素湿盛的人，又外感风寒湿邪，邪留肌肉，卫阳被郁，故见恶寒，发热，无汗，身体疼痛剧烈，不得安静等。

治以麻黄加术汤。麻黄汤散风寒湿邪；麻黄得白术，虽发汗而不致过汗，白术得麻黄，能行表里之湿，适合病情，取其微微汗出而解。如用火攻发汗，则大汗淋漓，风寒虽去，湿邪仍在，病不能除。或火热内攻，湿热相合，可能引起湿热内郁之黄疸。或火热内盛，迫血妄行，而为衄血等变证，应加注意。

【选注】

《医宗金鉴》：“湿家外证，身痛甚者，羌活胜湿汤；内证发黄甚者，茵陈五苓散。若惟身烦痛而不发黄者，则为外感寒湿，与麻黄加术汤发其汗，寒湿两解也。慎不可以火攻之者，谓不可以火劫大发其汗，必致变也。”

【病案举例】

单姓，女，37岁。时值初冬，因雨淋透衣襟，归后即发热恶寒，周身疼痛而重，少汗，头痛如裹。脉浮而紧，苔白而滑。证属风寒夹湿外侵，邪在太阳。治宜发汗解表，除湿散寒。方拟麻黄加术汤加味：麻黄6克，桂枝6克，杏仁10克，甘草4克，苍术12克，生姜3片，大枣3枚。

服药4剂，汗出表解，身痛解除，症状消失。治用原方去麻黄，调和脾胃，注意饮食起居。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,9:18）

21.病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也。可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

麻黄杏仁薏苡甘草汤方

麻黄去节，半两，汤泡 甘草一两，炙 薏苡仁半两 杏仁十个，去皮尖，炒上剉麻豆大，每服四钱，水一盏半，煮八分，去滓温服，有微汗避风。

【词解】

日晡所：指下午两点钟到六点钟左右的时间。

【诠解】

本条是论述风湿在表的证治。病人出汗时感受了风寒，或长时间贪凉感受寒湿，汗液留于皮内，变成湿邪，留著肌腠，以致全身疼痛发热。在日晡时，为阳明主气，当其旺时，正邪相搏则症状加剧。

治以麻黄杏仁薏苡甘草汤。方中麻黄散寒湿，杏仁利肺气以助治节；薏仁利湿健脾，甘草和中胜湿。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“《内经·太阴阳明篇》论曰：太阴阳明为表里，脾胃脉也，外合肌肉，故阳受风气，阴受湿气，所以风湿客之，则一身肌肉尽痛。夫阳气者，一日而主外，平旦阳气生，属少阳，日中阳气隆，属太阳，日西气门内闭，属阳明，是故阳明之气主乎申酉，所以日晡所剧也。”

22.风湿脉浮，身重，汗出恶风者，防己黄芪汤主之。

防己黄芪汤方

防己一两 甘草半两，炒 白术七钱半 黄芪一两一分，去芦

上剉麻豆大，每抄五钱匕，生姜四片，大枣一枚，水盞半，煎八分，去滓温服，良久再服。喘者加麻黄半两；胃中不和者加芍药三分；气上冲者加桂枝三分；下有陈寒者加细辛三分。服后当如虫行皮中，从腰下如冰，后坐被上，又以一被绕腰下，温令微汗，瘥。

【诠解】

本条是论述风湿表虚的辨证论治。风湿伤于肌表，故脉浮身重；卫阳素虚，而不固表，故汗出恶风。

治以防己黄芪汤，益卫气以祛湿邪。方中防己宣肺散风，通行经络，驱散湿滞；黄芪甘温扶虚，固秘卫阳止汗。黄芪合防己，又能善行肌表之水气；白术、甘草健脾化湿，扶正祛邪；生姜、大枣调和营卫，以胜湿邪。方后自注有：风湿闭塞肺气之喘者，加麻黄宣散风湿；湿邪困于脾胃作痛者，加芍药和脾气，利血脉止痛；水湿聚于下焦而又上冲者，加桂枝下气温化水湿之邪；寒湿凝聚而痹不通者，加细辛以散陈寒与痼冷。

【选注】

《金匱要略心典》：“风湿在表，法当从汗而解，乃汗不待发而自出，表尚未解而已虚，汗解之法不可守矣。故不用麻黄出之皮毛之表，而用防己驱之肌肤之里。服后如虫行皮中，及从腰下如冰，皆湿下行之征也。然非芪、术、甘草，焉能使卫阳复振，而驱湿下行哉？”

【病案举例】

张某，男，35岁，农民，于1978年4月8日诊治。

患者近期多次冒雨劳动，以致发热，关节酸痛，经服APC，抗生素治疗，热退，余症依然。面色萎黄，头重神疲，倦怠嗜卧，骨节酸楚，重滞难移，肘膝关节尤甚，汗出恶风，胃纳欠佳，舌苔白腻，脉濡涩。检查：肘、膝关节肿胀活动受限，血沉34毫米/小时，抗链“O”测定1250单位，诊断为风湿性关节炎。此属表虚夹湿之着痹，治以防己黄芪汤加减：黄芪、白术、宣木瓜各10克，汉防己15克，苡仁、徐长卿、茯苓各20克，滑石30克，通草5克，水煎服。

服五剂后，诸证均减，连服一个月后，血沉、抗链“O”均已正常。

（摘自《吉林中医药》1981,2:18）

23.伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之；若大便坚，小便自利者，去桂加白术汤主之。

桂枝附子汤方

桂枝四两，去皮 生姜三两，切 附子三枚，炮去皮，破八片 甘草二两，炙 大枣十二枚，擘

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

白术附子汤方

白术二两 附子一枚半，炮去皮 甘草一两，炙 生姜一两半，切 大枣六枚

上五味，以水三升，煮取一升，去滓，分温三服。一服觉身痹，半日许再服，三服都尽，其人如冒状，勿怪，即是术附并走皮中，逐水气未得除故耳。

【词解】

其人如冒状：冒，眩冒，即头晕。

【诠解】

本条是论述风湿兼阳虚的证治。外感风寒湿邪，八九日不解，邪仍在表，故脉浮；其人不呕不渴，反映邪未传少阳、阳明而未入里。风寒湿三气杂至合而为病，如留于肌表，风湿邪胜，表阳复虚，故脉浮而按之虚；湿盛痹着气血不利，故脉又涩；身体疼烦，不能自转侧，湿留关节之候。

治宜桂枝附子汤，温经助阳，以散寒湿。方中桂枝散风寒，温通经络，温化湿邪；附子温阳化湿，温经通痹；生姜散风寒湿邪；甘草、大枣补脾胃，而调和营卫。

服桂枝附子汤后，阳气通达，气化已行，湿邪减少，故见大便已实，小便通利。宜用白术附子汤，即桂枝附子汤去桂枝加白术而成，以

奏温经复阳，行化表湿之功。服白术附子汤第一服时，可出现周身如痹，反映药力已行，再服，以至三服都尽，其人头目如冒而似眩晕，不用责怪，这是附子与白术的药力逐除水湿之邪未尽的表现。

【选注】

《金匱要略心典》：“身体疼烦，不能自转侧者，邪在表也；不呕不渴，里无热也；脉浮虚而涩，知其风湿外持而卫阳不正。故以桂枝汤去芍药之酸收，加附子之辛温，以振阳气而敌阴邪。若大便坚，小便自利，知其在表之阳虽弱，而在里之气犹治，则皮中之湿，自可驱之于里，使从水道而出，不必更发其表，以危久弱之阳矣。故于前方去桂枝之辛散，加白术之苦燥，合附子之大力健行者，于以并走皮中而逐水气，亦因势利导之法也。”

【病案举例1】

梁某，男，成年。素易感冒，1975年8月，忽觉恶风，微汗出，周身筋肉酸痛沉重，卧而难以转侧，四肢关节屈伸不利，无头痛项强，口渴呕吐等症，二便调，口淡，舌淡苔白，脉浮虚，体温38.5℃。前医以三仁汤加减治疗未效而转诊，笔者认为，此证为阳虚之体，感受风寒湿，为痹证之初。正如《伤寒论》所说：“风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。”故投以：桂枝10克，熟附子12克，生姜3片，大枣6枚，炙甘草6克，服三剂，诸证消失而愈。

按语：桂枝附子汤，源出《伤寒论》和《金匱要略》一书，属辛温之剂，原药物为：桂枝、炮附子、生姜、大枣、炙甘草。它的作用为：桂枝祛风，配附子温阳行湿，甘草、姜、枣和中养胃，有祛风除湿，和中养胃之效，而风寒湿邪侵袭体表，卫阳与之抗争，必见发热，一般多因此而不敢用桂、附。家属因顾虑病情加重，在煎药时减少附子一半，不料病者服药后，诸证减轻，体温亦减。余下两剂，即放心使用，药完病愈。由此可见，发热并不是不能使用桂、附，只要谨守病机，求其根本是关键，如有阳虚脉证而用之，即能达到效果。

（摘自《新中医》1980,2:30,）

【病案举例2】

患者黄某，男，62岁，农民，1979年12月18日初诊。患习惯性便秘已多年，平时4~5日大便一次，稍吃辛辣刺激食物，则大便干结如羊矢。但虽便秘，腹部常无所苦，故未坚持治疗。近因连日阴雨，气候寒冷，三天前因劳动不慎跌入水中，第二日开始恶寒发热，全身酸痛，经自服紫苏姜酒后，恶寒已差，但全身酸痛未减，特别腰以下肌肉骨节疼

痛难忍，以致坐卧不安，因而来诊。诊得舌苔白厚而润，舌质淡红，脉弦缓。因询及二便情况，获知患有习惯性便秘，现已三日未通大便，小便稍黄，因而联想到《伤寒论》桂枝附子去桂加白术汤证与此很相似，不妨一试，遂处该方一剂：白术60克，附子10克，炙甘草6克，生姜10克，红枣5克。第二日复诊，恶寒已罢，身痛减轻，大便通，量多，再一剂，痊愈。

（摘自《福建中医药》1981,1:37）

24.风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

甘草附子汤方

甘草二两，炙 附子一枚，炮去皮 白术二两 桂枝四两，去皮

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服，初服得微汗则解。能食汗出复烦者，服五合。恐一升多者，服六七合为妙。

【诠解】

本条是论述风湿病阳气虚的辨证论治。病人感受风寒湿邪，三邪盛于关节体表，而阳气复虚，故见骨节疼痛，而又掣痛不得屈伸，近之则痛剧；阳虚不能固表则汗出短气；寒湿盛而阳不化，故又小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿，此乃阳虚而邪气盛的反映。

治宜甘草附子汤，助阳温经，益气化湿。方中甘草、白术健脾化湿；附子、桂枝温阳通气，宜行营卫，化湿散风。本方扶正祛邪，补中有发，温阳益气，对风湿性心脏病起到正邪兼顾的作用。

【选注】

《医宗金鉴》：“风湿相搏，身体烦疼重着，不能转侧者，湿胜风也。今掣痛不可屈伸，风胜湿也。掣痛不可屈伸，近之则痛剧，汗出、短气、恶风不欲去衣，皆风邪壅盛也。小便不利，湿内蓄也。身微肿者，湿外搏也。以甘草附子汤微汗之，祛风为主，除湿次之也。此上二条，皆详风湿之义，以明风湿之治也。”

【病案举例】

宫某，女，47岁，1973年8月来诊。主诉：久病腰疼，二个月前继发功能性子宫流血，经刮宫血止。但身体逐渐虚弱多病，周身关节疼

痛，初为走窜，近一个月痛有定处，手背及腕关节肿痛。继而肌肉隐有红色斑片，掣痛不得屈伸，触之则痛剧，夜重有碍睡眠，汗出渗透衬衣及被单，恶寒喜暖，头晕乏力，尿涩，尿道痛，面色晦暗，痛苦病容，舌苔薄白而燥，脉象弦。诊为气血不充，寒湿侵袭脉络，郁久化热。治法：补气养血，疏风散寒，清热利湿。

方药：党参40克，二术各15克，附子15克，桂枝20克，白芍20克，当归30克，川芎15克，红花15克，防己15克，大芩20克，甘草15克，滑石20克，元柏15克，仙遗粮40克，水煎服。

上方连服4剂，手腕肿痛、尿涩减轻，但周身疼与夜汗不解，仍按上方加芪、龙、牡等品，连服数日不效。遂忆及甘草附子汤所主诸症与本症相似，遂改用本方：桂枝50克，附子15克，白术25克，甘草25克。水煎分两次服。一剂疼止得寐，汗出大减。连服8剂，痊愈出院。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,5:15）

25.太阳中喝，发热恶寒，身重而疼痛，其脉弦细芤迟，小便已，洒洒然毛耸，手足逆冷，小有劳，身即热，口开前板齿燥，若发其汗，则其恶寒甚；加温针则发热甚；数下之则淋甚。

【词解】

中喝：即中暑。

【诠解】

本条论述中暑的证治特点。中暑是有季节性的，古人说：先夏至为病温，后夏至为病暑。夏天伤于暑邪，暑热则耗阴伤气，故见口开喘息，门齿干燥，发热，心烦，口渴，汗出等。或者由于暑热而又乘凉饮冷，反使寒邪伤于外，湿伤于中，故又见发热，恶寒，呕吐，泄泻，身重而且疼痛等。卫阳不达于四肢，故手足厥冷。暑热伤气则脉芤，暑热伤阴则脉细；寒伤于外则脉弦紧，寒湿伤于中则脉迟，此证如言其脉则有弦细芤迟之变。本病既有寒伤于外，而又阳气内虚，若发其汗，则阳气外散，故恶寒更甚；本病寒湿伤中，而又有阴气虚，若更加温针则伤阴分而发热甚。本病湿伤于中，又有津液亏耗，若再下之，则津液内竭，必小便混浊涩痛。本病属于伤暑之病，阳气已虚，动则阳气浮于外，故小有劳，身即发热。小便已，膀胱之气不支，卫阳更感不足，故形寒毫毛耸立。

【选注】

《金匮要略方论本义》：“太阳主表，六淫之邪，必先中之，故中喝亦为太阳病，虽所受之邪不同，而所感之分则同也。发热者，客邪在

表；恶寒者，热盛于里；身重而疼痛者，挟湿则身重，挟寒则疼痛也。诊之脉弦细，弦者，寒在表也，细者，热挟湿也，再见芤迟，芤者，中气之虚，迟者，腹中之寒。合脉诊而谛之，而中喝之病可识矣。再征之于余证：小便已，洒洒然毛耸，太阳之表有邪，则膀胱腑应之，小便时气动于膀胱，必连及皮毛，洒洒然，恶风寒之状也；再验之于手足厥冷，内热极而寒见于四末，且内热为寒湿所郁，其气阻而不宣，亦可逆见手足，皆内热外寒之象也。小有劳，身即热，热病阴虚，动则生阳也；口开前板齿燥，热盛于内，欲开口以泄其气，气出而内热熏灼于板齿，则齿燥也。此为内热积盛之证，若单感喝邪者，内外俱是阳邪，若兼寒湿者，内为阳邪，而外为阴邪，非兼治其内外不为功也。”

26.太阳中热者，喝是也，汗出恶寒，身热而渴，白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方

知母六两 石膏一斤，碎 甘草二两 粳米六合 人参三两

上五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

【诠解】

本条是论述中暑的证治。夏天感受暑热邪气，伤气耗阴，暑热炽盛，故身热，汗出，恶寒。暑热伤阴，故见口渴，心烦，尿赤。

治以白虎加人参汤，清热解暑，益气生津。方中石膏清表里之热；知母滋阴清热；甘草、粳米益胃生津；人参则补气生津，保元固本。

【选注】

《金匱要略心典》：“中热亦即中暑，喝即暑之气也。恶寒者，热气入则皮肤缓，腠理开，开则洒然寒，与伤寒恶寒者不同。发热汗出而渴，表里热炽，胃阴待涸，求救于水，故与白虎加人参以清热生阴，为中暑而无湿者之法也。”

27.太阳中喝，身热疼重，而脉微弱，此以夏月伤冷水，水行皮中所致也。一物瓜蒂汤主之。

一物瓜蒂汤方

瓜蒂二七个

上剉，以水一升，煮取五合，去滓顿服。

【诠解】

本条是论述暑病挟湿的辨证论治。病人中于暑热，邪在太阳之表，故身发热；又伤冷水（或饮或浴），水行皮中，故身疼；中暑伤气，气伤而虚，故脉微弱。治用瓜蒂散，治身面四肢浮肿，散皮肤中水气，苦以泄之法也。

【选注】

《金匱要略心典》：“暑之中人也，阴虚而多火者，暑即寓于火之中，为汗出而烦渴；阳虚而多湿者，暑即伏于湿之内，为身热而疼重。故暑病恒以湿为病，而治湿即所以治暑。瓜蒂苦寒，能吐能下，去身面四肢水气，水去而暑无所依，将不治而自解矣。此治中暑兼湿者之法也。”

结语

本篇论述痉、湿、喝三病的辨证论治。痉病的成因，为外感风寒邪气，又津液不足，不能滋润筋脉所致。症状以项背强急，口噤不开，甚至角弓反张为主。脉象按之紧如弦，直上下行。痉病辨证应分刚痉、柔痉、实热痉三种：刚痉为表实无汗，故用葛根汤；柔痉为表虚有汗，则用桂枝加葛根汤；若脉反沉迟者则用栝楼桂枝汤；实热痉为阳明燥热伤津证，宜用大承气汤。

湿病成因，为外感风寒湿邪，症状以身体疼重，骨节烦疼为主。湿病的辨证，表实无汗者，用麻黄加术汤；日晡所剧疼痛者，用麻杏薏甘汤；表虚汗出者，用防己黄芪汤；如寒湿盛胜而阳气微者，当选用桂枝附子汤、白术附子汤、甘草附子汤以助阳气化寒湿，正邪兼顾为宜。总的来说，在治湿方中，有以发汗去邪为主；有以温通经络，利关节止痛为主；有以温阳利湿，开痹化凝等治法为主，如能结合临床实际，很有实践意义。

喝即暑病，暑病的辨证可分暑热和暑湿两类。本篇对暑病的气阴两伤，以及暑中兼有寒湿等证，进行了分析，并举出了治疗的方法，较为全面。

百合狐惑阴阳毒病证治第三

概说

本篇是论述百合、狐惑、阴阳毒三种病的辨证论治。篇中共有条文十五条，载方十二首。其中第一条为百合病的总论，阐述百合病发病机理、脉证和转归。第二条至第九条是论百合病的证治和各种变证的治法。第十条至十三条则是阐述狐惑病的辨证和方药。第十四、十五两条则叙述了阴阳毒的证治。本篇所论的三种疾病，皆由热病传变而来，其症状表现有类似之处，如百合病的常默然、欲卧不能卧，和狐惑病的默默欲眠、目不得闭、卧起不安等症相似。狐惑病有蚀于喉的病变，而阴阳毒病，也有咽喉疼痛之症。所以三病合于一篇讨论，以资鉴别分析。

百合病可发生在温热病之后，或由情志不遂，引起阴虚内热，精神恍惚，饮食和行动失常，口苦，尿赤，脉微数等。

狐惑病是因湿热之毒蕴结于里所引起的疾患。有目赤，咽喉和前后阴腐蚀等。由于本证古名狐惑病。后世医家则称为“疳”，分为牙疳和下疳。

阴阳毒是阴毒病和阳毒病的总称，因疫毒之邪，蕴于血脉而成。阴毒有面目青、身痛如被杖、咽喉痛等；阳毒有面赤斑斑如锦文、咽痛、吐脓血等。由于阴阳毒是感受疫病毒邪，故有一定的传染性。

1.论曰：百合病者，百脉一宗，悉致其病也。意欲食复不能食，常默然，欲卧不能卧，欲行不能行，饮食或有美时，或有不用闻食臭时，如寒无寒，如热无热，口苦，小便赤，诸药不能治，得药则剧吐利，如有神灵者，身形如和，其脉微数，每溺时头痛者，六十日乃愈；若溺时头不痛，淅然者，四十日愈；若溺快然，但头眩者，二十日愈。其证或未病而预见，或病四五日而出，或病二十日或一月微见者，各随证治之。

【词解】

百脉一宗：是指人之血脉，分之则为百脉，合之则为一宗。百脉朝

宗于肺，故百脉不可注，而可注其肺。

如有神灵者：指百合病诸药不能治，得药则剧吐利，全是恍惚不定，去来不可凭，如有（像似）神灵所为。

身形如和：从患者的身体上观察，也没有显著病态，好像没有什么病。

【诠解】

本条论述百合病的病因、病机、症状和预后。百合病是由心血肺阴两虚，阴虚内热引起的疾病。是因热病之后，阴血未复，余热未尽，消烁津液；或因平素思虑伤心，情志不遂，郁结化火，耗津烁液，而使心血肺阴两伤，阴虚内热，则百脉俱受其累，以致百脉不和，症状百出，故曰：“百脉一宗，悉致其病也。”

由于心血肺阴亏损，虚热内盛，热邪散漫，未归于一经，而游走于百脉。脉朝于肺而系于心，心神失慧，而有意欲食，复不能食，欲卧不能卧，欲行不能行等似是而非，全是恍惚去来不可为凭之象。惟口苦，小便赤，脉微数三证，则反映了内有邪热不解。若其人每溺时而头痛者，此乃热邪之甚者，必俟六十日之久，使阴气复而病则愈；若溺时头不痛，而淅淅然畏恶风寒者，则病势稍浅，必等四十日方愈；若溺时快然，但头眩者，则邪更浅，不过二十日便可愈。此证每见于热病之后，也有或未病而预见，或先见，或后见等等不同，应各随其证而治之。

至于溺时而头痛等的病机：因肺有通调水道，下输膀胱的功用，膀胱经脉行于脊背，上行至头项，入络脑。溺时阳气下泄，不上充于头，故见头痛。此为阳气衰弱，病情较重，故曰：六十日乃愈；如溺时头不痛，淅然者，为阳气下泄，卫阳虚弱，不能温暖肌表，病情较轻，故曰：四十日愈；如溺时快然，头眩者，为阳气稍虚之头眩，乃病情之最轻者，故曰：二十日愈。如上所述，百合病因病情的轻重不同，症状也不相同，病愈亦长短不一。至于二十日、四十日、六十日，乃大约之数，不可拘泥。

【选注】

《金匱要略心典》：“百脉一宗者，分之则为百脉，合之则为一宗。悉致其病，则无之非病矣。然详其证：意欲食矣，而复不能食；常默然静矣，而又躁不得卧；饮食或有时美矣，而复有不欲闻食臭时；如有寒，如有热矣，而又不见为寒，不见为热；诸药不能治，得药则剧吐利矣，而又身形如和。全是恍惚去来，不可为凭之象。惟口苦、小便赤、脉微数，则其常也。所以者何？热邪散漫，未统于经，其气游走无

定，故其病亦去来无定。而病之所以为热者，则征于脉，见于口与便，有不可掩然者矣。夫膀胱者，太阳之府，其脉上至巅顶，而外行皮肤。溺时头痛者，太阳乍虚，而热气乘之也；渐然、快然，则递减矣。夫乍虚之气，溺已即复；而热淫之气，得阴乃解。故其甚者，必六十日之久，诸阴尽集，而后邪退而愈；其次四十日；又其次二十日，热差减者，愈差速也。此病多于伤寒热病前后见之；其未病而预见者，热气先动也；其病后四五日，或二十日，或一月见者，遗热不去也。各随其证以治，具如下文。”

2.百合病发汗后者，百合知母汤主之。

百合知母汤方

百合七枚，擘 知母三两，切

上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓；别以泉水二升煎知母，取一升去滓；后合和煎取一升五合，分温再服。

【诠解】

本条论述百合病误用汗法后的证治。百合病有如寒无寒、如热无热等证。医生误认为是表实证，而发其汗，汗后伤津，心血肺阴而更虚，则虚热加重，故出现心烦、口渴等。

治以百合知母汤，养阴清热，润燥除烦。方中百合清心润肺，益气安神；知母清热除烦，养阴止渴；配泉水清热利尿，导热下行。三药相合，以奏养阴除热之功。

【选注】

《医宗金鉴》：“百合病不应汗而汗之，不解者则致燥。以百合知母汤主之者，清而润之也。”

3.百合病下之后者，滑石代赭汤主之。

滑石代赭汤方

百合七枚，擘 滑石三两，碎绵裹 代赭石如弹丸大一枚，碎绵裹

上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升煎取一升，去滓；别以泉水二升煎滑石、代赭，取一升去滓，后合和重煎取一升五合，分温服。

【诠解】

本条论述百合病误用下法后的证治。百合病有意欲食，复不能食，口苦，尿赤，脉微数等证。医生误认为是里实证，而反下之，以致津液更伤，内热加重，故常见小便短赤而涩。又因苦寒泻下之品，伤其胃气，故胃气上逆而致哕。

治以滑石代赭汤，滋阴清热，和胃降逆。方中百合滋润心肺，益气安神；滑石清热利尿，代赭石和胃降逆；配泉水引热下行。

【选注】

《金匱要略论注》：“其在下后者，下多伤阴，阴虚火逆，故以百合合同滑石之走窍，代赭之镇逆者以通阳气，加之泉水以泻阴火，而阴气自调也。”

4.百合病吐之后者，用后方主之。

百合鸡子汤方

百合七枚，擘 鸡子黄一枚

上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升煎取一升，去滓，内鸡子黄，搅匀煎五分，温服。

【诠解】

本条论述百合病误用吐法后的证治。百合病有不欲闻食臭等证，医生误认为宿食停滞，而用吐法，更损肺胃之阴，且扰胃之和降之气，则虚烦不安，而胃中不和。

治以百合鸡子汤，养阴润燥除烦，方中百合滋养肺胃之阴，清热除烦；鸡子黄养阴润燥，安五脏之气，能除虚烦；泉水养阴泄热。

【选注】

《金匱要略论注》：“吐伤元气，而阴精不上奉，故百合病在吐后者，须以鸡子黄之养阴者同泉水以滋元阴，协百合以行肺气，则血气调而阴阳自平。”

5.百合病不经吐、下、发汗，病形如初者，百合地黄汤主之。

百合地黄汤方

百合七枚，擘 生地黄汁一升

上以水洗百合渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升煎取一升，去滓，内地黄汁煎取一升五合，分温再服，中病勿更服，大便常如漆。

【诠解】

本条论述百合病未经汗、吐、下的正治之法。百合病由于心血肺阴两虚，阴虚内热，邪气流于百脉，而成百合病。

治以百合地黄汤，养心血，滋肺阴，凉血清热。方中百合养肺阴，清虚热；生地黄益营凉血，滋阴降火，调和血脉；泉水利小便，泄虚热。三药相合，使阴气充，热邪去，百脉调和，病可自愈。

【选注】

《医宗金鉴》：“百合一病，不经吐、下、发汗，病形如初者，是谓其病迁延日久，而不增减，形证如首章之初也。以百合地黄汤，通其百脉，凉其百脉。中病勿更服，恐过服生地黄，大便常如漆也。”

【病案举例】

连某，男，48岁，干部，于1980年10月14日来诊。一个月前因生气精神不好，性情急躁，少寐多梦，纳呆，口苦，小便短赤。近一周来坐卧不安，烦躁不宁，多疑，夜间尤甚。现证：神疲体倦，走路有欲倒之势，欲食不能食，欲卧不能卧，曾多次去医院诊治，投安神镇静之品和舒肝理气、豁痰清热之药均无效。既往史：患阳痿5年。查体：一般状态尚可，神清语明，舌质红，舌尖赤，苔微黄，脉沉细而数。综上脉证合参为肾虚累及心肺，阴虚生内热，百脉失其濡养所致。诊为百合病，治以滋阴清热，养心安神，方用百合地黄汤、知柏地黄汤加减。

处方：百合100克，生地15克，知母15克，山药15克，茯苓15克，炒枣仁20克，甘草10克。两剂，日一剂，水煎服。

10月16日二诊：服药后诸证减其大半，小便通畅，口中和，能进饮食但量少，能入睡，舌苔已退，药已应症，继用前法前方加龟板15克，三剂。

10月19日三诊：诸症基本消失，精神已恢复正常，饮食增加，睡眠安适，仍感腰酸乏力。再守上方六剂。

10月25日四诊：诸症消失，已上班，阳痿亦有好转，改用新六味地黄丸以治本。

（摘自《吉林中医药》1981,4:37）

6.百合病一月不解，变成渴者，百合洗方主之。

百合洗方

上以百合一升，以水一斗渍之一宿，以洗身，洗已，食煮饼，勿以盐豉也。

【词解】

煮饼：可能是面条一类食物。

【诠解】

本条是论百合病变证的治法。由于心肺阴虚内热，一月不解，阴津亏损，虚火亢盛，故见口渴，只用百合地黄汤药力不足，配用百合洗方，以百合渍水洗身。外洗皮表，其气通肺，以清肺热。内服外洗，共收养阴清热之效。洗已汗出而胃知饥，则食以煮饼，益气养津，清热止渴。勿以盐豉佐食，恐其味咸伤血，耗津增热而变渴。

【选注】

《医宗金鉴》：“百合病本不渴，今一月不解，变成渴者，外以百合汤浸洗其身，通表泻热；内食煮饼，勿以盐豉，不致引饮，而渴自止也。”

7.百合病渴不差者，栝楼牡蛎散主之。

栝楼牡蛎散方

栝楼根 牡蛎熬，等分

上为细末，饮服方寸匕，日三服。

【诠解】

本条又论述百合病渴而不差的治法。上述之百合病，若服百合地黄汤及百合洗方，而其渴仍不差者，此为热伤津液之所致，可用栝楼牡蛎散主之。

栝楼牡蛎散方，有生津止渴、收敛浮热的作用。方中栝楼根气凉性润，启发脾阴，上承津液，而止口渴；牡蛎则敛摄在上之阳热，开散凝滞水饮。以上二味，一升一降，使其阴阳调和，口渴自解。

【选注】

《金匱要略论注》：“渴不差，是虽百合汤洗而无益矣。明是内之阴气未复，阴气未复，由于阳亢也，故以栝楼根清胸中之热，牡蛎清下焦之热，与上平阳以救阴同法，但此从其内治耳，故不用百合而作散。”

8.百合病变发热者一作：发寒热，百合滑石散主之。

百合滑石散方

百合一两，炙 滑石三两

上为散，饮服方寸匕，日三服，当微利者止服，热则除。

【诠解】

本条三论百合病变发热证的治法。由于心血肺阴两虚，虚热游走百脉无定，气血乱于表，故如寒无寒，如热无热。变发热者，为虚热郁结，热郁于上，气行不畅，湿郁于下，湿热相合，故发热，口苦，脉数，尿赤。

治以百合滑石散，滋阴清热，利湿通郁。方中百合滋阴济阳，清润心肺；滑石利水，渗湿以解热。以上二味，一为滋阴润燥，而去在上之虚热；一为滑利水道，而通在下之湿郁，津液通济，其热可清。

【选注】

《金匱要略论注》：“仲景尝谓发于阳部，其人振寒而发热，则知变发热者，内热不已，淫于肌肤，而阳分亦热，故以滑石清腹中之热，以和其内，而平其外，兼百合清肺气以调之；不用泉水，热已在外，不欲过寒伤阴，故曰当微利，谓略疏其气，而阴平热则除也。”

9.百合病见于阴者，以阳法救之；见于阳者，以阴法救之。见阳攻阴，复发其汗，此为逆；见阴攻阳，乃复下之，此亦为逆。

【诠解】

本条论述百合病的治疗顺逆。百合病是由于心血肺阴两虚，阴虚生热，内热耗损阴气，然病见于阴，甚必及阳，故其症状有见于阴和见于阳之分，如见于阳则常默然、欲卧、不能行、如寒、无热、不能食、不用闻食臭；见于阴，则意欲食、饮食或有美时、无寒、如热、不能卧、欲行、口苦、脉微数、小便赤。治疗之法，不外用阴和阳，用阳和阴，使其阴阳平秘则病愈。

若医计不出此误用发汗之法，则更伤其阳，故曰：此为逆。同样，若误用攻下之法，则更伤其阴，故曰：见阴攻阳，乃复下之，此亦为逆。由此可见，百合病治疗方法是见阳救阴，见阴救阳，以调和阴阳，恢复阴阳平衡状态，则病自愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“病见于阴，甚必及阳；病见于阳，穷必归阴。以法救之者，养其阳以救阴之偏，则阴以平而阳不伤；补其阴以救阳之过，则阳以和而阴不敝。《内经》‘用阴和阳，用阳和阴’之道也。若见阳之病而攻其阴，则并伤其阴矣，乃复发汗，是重伤其阳也，故为逆；见阴之病而攻其阳，则并伤其阳矣，乃复下之，是重竭其阴也，故亦为逆。以百合为邪少虚多之证，故不可直攻其病，亦不可误攻其无病如此。”

10.狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安。蚀于喉为惑，蚀于阴为狐，不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白，蚀于上部则声喝一作：嘎，甘草泻心汤主之。

甘草泻心汤方

甘草四两 黄芩 人参 干姜各三两 黄连一两 大枣十二枚 半夏半升
上七味，水一斗，煮取六升，去滓，再煎温服一升，日三服。

【词解】

状如伤寒：发热恶寒如同伤寒之证。

蚀：是指腐蚀。

声喝：是指声音嘶哑，或作嘎，两字相同。

【诠解】

本条是论述狐惑病的症状及治疗。本病是因湿热久蕴而生虫，且蒸腐气血，内损心肺，外伤咽喉，咽喉腐蚀糜烂，则声音嘶哑，名叫“惑”病；若内损肝肾，虫蚀前后二阴，阴部腐蚀溃烂，而叫“狐”病。若内伤脾胃，运化失常，故不欲饮食，恶闻食臭。湿热内困心神，故默默欲眠，目不得闭，而卧起不安。湿热为病，热上蒸，故其面目乍赤；湿上遏，故其面目乍黑；湿热下行，则面目乍白。

治疗之法，上蚀于喉的，应宜清热解毒，泻心扶正，治用甘草泻心汤。方以甘草扶正解毒；配以黄芩、黄连清热而燥湿；干姜、半夏辛燥行气以化湿；人参、大枣补中健运，以运湿邪。诸药相合，乃调中焦阴阳，而使脾气健运，湿毒自化，则其证可解。

【选注】

《金匱要略论注》：“狐惑虫也，虫非狐惑而因病以名之，欲人因名思义也。大抵皆湿热毒所为之病，毒盛在上，侵蚀于喉为惑，谓热淫如惑乱之气感为生蛾也，毒偏在下，侵蚀于阴为狐，谓柔害而幽隐如狐性之阴也。蚀者若有食之而不见其形，如日月之蚀也。”

【病案举例】

解某，男，43岁。口腔、肛门、龟头出现红色，如炎症初起，随之即溃烂皮破，日久不愈。西医诊断为“白塞综合征”，治疗七十余日，唯龟头之糜烂毫不见效。切其脉弦细，观舌质红而苔白。辨为肝肾阴虚有热，且伏有湿_蠱之邪。

外用处方：珍珠3克，青黛3克，轻粉1克，共研细末，涂敷疮面。

内服处方：熟地30克，山药18克，丹皮10克，赤苓10克，川楝子10克，使君子10克，当归10克，川芎6克。水煎内服。

经内外兼治，不到一个月病愈。

（刘渡舟治验）

11.蚀于下部则咽干，苦参汤洗之。

苦参汤方

苦参一升

以水五升，煎取七升，去滓熏洗，日三服。

【诠解】

本条是论述狐惑病蚀于前阴的外治法。湿热腐蚀于下，则前阴苦痒，甚或溃烂；湿热循经上熏咽喉，故咽干。

治以苦参汤，熏洗患处。苦参清热燥湿，解毒杀虫，更治前阴虫痒溃烂之疾。

【选注】

《金匱要略论注》：“下部毒盛，所伤在血而咽干，喉属阳，咽属阴也，并用苦参熏洗，以去风清热杀虫也。”

12.蚀于肛者，雄黄熏之。

雄黄熏方

上一味为末，筒瓦二枚合之，烧向肛熏之。

《脉经》云：病人或从呼吸上蚀其咽，或从下焦蚀其肛阴。蚀上为惑，蚀下为狐，狐惑病者，猪苓散主之。

【诠解】

本条是论狐病蚀于肛门的治法。由于湿热生虫，蚀于后阴，作痒作痛，肛门溃烂。此证包括近世的“白塞综合征”。如前阴破损者，可用珍珠粉敷之。治以雄黄熏法，雄黄有解毒除湿杀虫的功效。此方亦治寸白虫（蛲虫），在临床上用之有效。

【选注】

《医宗金鉴》：“李彰曰：喉肛与前阴，皆关窍所通，津液滋润之处，故虫每蚀于此。”

13.病者脉数，无热微烦，默默但欲卧，汗出。初得之三四日，目赤如鸠眼，七八日目四眦一本此有黄字黑；若能食者，脓已成也。赤小豆当归散主之。

赤小豆当归散方

赤小豆三升，浸令芽出，曝干 当归

上二味，杵为散，浆水服方寸匕，日三服。

【词解】

无热：谓无寒热，是无表证的互词。

鸕：鸟名，俗称斑鸕，其目色赤。

四眦：指两眼内外眦。

【诠解】

本条论述狐惑病成脓的证治。病者无热，表示病不在表。由于湿热内盛，困扰心神，则脉数，微烦，默默但欲卧；湿热外蒸，腠理开泄，故汗出；湿热郁于血分，蓄热不去，随肝经上注于目，则目赤如鸕眼；若湿热壅遏，日久不解，蒸腐血肉而化脓，故目四眦黑；化脓之时，病势局限，对脾胃影响较轻，所以病人能食。

治以赤小豆当归散，清热解毒，活血化脓。方中赤小豆渗湿清热，解毒排脓，以散恶血；当归活血养血，去腐生新；浆水清凉解热。三药同用，脓除毒解，热退湿化，其病可愈。

本证的化脓部位，可在喉部、阴部、肛门、或大肠下端、或眼球前房积脓。关于初得之三四日和七八日的时间，皆是约略之数，可不拘泥，仍以病证变化为准。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉数微烦，默默但欲卧，热盛于里也。无热汗出，病不在表也。三四日目赤如鸕眼者，肝脏血中之热，随经上注于目也。经热如此，脏热可知，其为蓄热不去，将成痈肿无疑。至七八日目四眦黑，赤色极而变黑，则痈尤甚矣。夫肝与胃，互为胜负者也。肝方有热，势必以其热侵及于胃；而肝既成痈，胃即以其热并之于肝，故曰若能食者，知脓已成也。且脓成则毒化，毒化则不特胃和而肝亦和矣。赤豆、当归，乃排脓血、除湿热之良剂也。

再按此一条，注家有目为狐惑病者，有目为阴阳毒者，要之亦是湿热蕴毒之病，其不腐而为虫者，则积而为痈。不发于身面者，则发于肠脏，亦病机自然之势也。仲景意谓与狐惑、阴阳毒，同源而异流者，故特论列于此欤？”

14.阳毒之为病，面赤斑斑如锦文，咽喉痛，唾脓血。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤主之。

升麻鳖甲汤方

升麻二两 当归一两 蜀椒炒去汗，一两 甘草二两 鳖甲手指大一片，
炙 雄黄半两，研

上六味，以水四升，煮取一升，顿服之，老小再服。取汗。

《肘后》、《千金方》：阳毒用升麻汤，无鳖甲有桂；阴毒用甘草汤，无雄黄。

【词解】

锦文：有彩色花纹的丝织品。

老小再服：老人和小孩，分两次服。

【诠解】

本条论述阳毒的证治。阳毒是因感受天地疫疠火毒之气，火毒内蕴，扰于营血，血热行于皮下，故面赤斑斑如锦文；火毒上灼咽喉，则咽喉疼痛；火毒蒸腐胸膈气血，血肉腐败，而吐脓血。由上可知，本证病势凶险，应在邪气未盛，正气不衰，易于治疗之时治之。若待正虚邪盛，则较为难治，故曰：“五日可治，七日不可治。”

治以升麻鳖甲汤，清热解毒，活血排脓。方中升麻、甘草清热解毒，可治时气疫疠之喉痛；当归、鳖甲活血凉血，散瘀排脓，养阴清热；雄黄辛温，散瘀解毒；蜀椒温中止痛；雄黄、蜀椒均为温热之品，可助升麻、甘草解毒之力，又能助鳖甲、当归散瘀排脓之功。诸药合用，热除毒解，阳毒可愈。

15.阴毒之为病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒主之。

【词解】

身疼如被杖：身疼好似被木杖击打的一样疼痛。

【诠解】

本条论述阴毒的证治。阴毒是感受天地疫疠阴阳之气，毒邪痼结于里，血瘀凝滞，经脉阻塞不通，故面目色青；经脉阻塞，血流不通，则身痛如被杖；疫疠毒邪结于咽喉，故咽喉疼痛。“五日可治，七日不可治”，其义同前。

治以升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒，解毒化瘀祛邪。

【选注】

《金匱要略心典》：“毒者，邪气蕴蓄不解之谓。阳毒非必极热，阴毒非必极寒。邪在阳者为阳毒，邪在阴者为阴毒也。而此所谓阴阳者，亦非脏腑气血之谓，但以面赤斑斑如锦纹、咽喉痛、吐脓血，其邪著而在表者谓之阳；面目青、身痛如被杖、咽喉痛、不吐脓血，其邪隐而在表之里者谓之阴耳。故皆得用辛温升散之品，以发其蕴蓄不解之邪；而亦并用甘润咸寒之味，以安其邪气经扰之阴。五日邪气尚浅，发之犹易，故可治；七日邪气已深，发之则难，故不可治。其蜀椒、雄黄二物，阳毒用之者，以阳从阳，欲其速散也；阴毒去之者，恐阴邪不可劫，而阴气反受损也。”

结语

百合病的病机为心肺阴血两虚，阴虚生热，病气游走百脉，症状百出而捉摸不定。治疗应以滋养心肺阴血，清除虚热而为法，故以百合地黄汤为代表方。本病因有误治和变证的不同，因而在治疗上亦有所不同。如误汗之后，用百合知母汤治之；误下之后，用滑石代赭汤治之；误吐之后，用百合鸡子黄汤治之。若百合病变渴者，用百合洗方治之；若渴不差者，则用栝楼牡蛎散治之；若变发热者，则用百合滑石散主之。

狐惑病的病机是湿热生虫，腐蚀气血而引起的疾患，治以清热解毒、化湿扶正为主。若虫蚀于上部叫做“惑”，则声嘎，用甘草泻心汤治之；蚀于前阴的叫做“狐”，则因黏膜溃破，可用苦参汤洗之；蚀于后阴，用雄黄熏之；若狐惑成脓，目眦黑而能食，用赤小豆当归散，清热解毒，活血排脓。

阴阳毒的病因是感受天地疫疠毒气所致，有传染性。两者均有咽喉痛，但阳毒以面赤斑斑如锦纹、吐脓血为主证，用升麻鳖甲汤清热解毒，活血排脓；阴毒以面目色青、身痛如被杖为主证，用升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒，解毒散瘀。

疟病脉证并治第四

概说

本篇是论述疟病的辨证论治，并根据疟病的不同症状，将疟病分为瘧疟、温疟、牡疟三种类型，并且指出疟病日久不愈，可以形成癥瘕和疟母。篇中共有条文五条，载方六首，其中包括附方三首。本篇中第一、三条阐述疟病的脉证、病机，以及辨证和治疗原则。第二、四、五条为疟病的证治和方药。

疟病的病变部位虽在半表半里，但往往挟有伏邪为病，故与一般的少阳病证有所不同，所以治疗也不一样。如一般的少阳病，则禁用汗吐下三法，而疟疾的治疗可以用汗吐下三法治疗。

1.师曰：疟脉自弦，弦数者多热，弦迟者多寒。弦小紧者下之差，弦迟者可温之，弦紧者可发汗、针灸也，浮大者可吐之，弦数者风发也，以饮食消息止之。

【词解】

弦小紧：是指脉形弦细，而又紧急有力。

差：同瘥。指病愈的意思。

风发：是指阳邪动风之象。

消息：有观察斟酌的意思。

【诠解】

本条论述疟病的辨证论治。疟病是邪伏少阳之半表半里部位，若邪入里与阴相争则恶寒；若外出与阳相争则发热，故有寒热往来之证。疟邪病于少阳，少阳脉弦，所以，疟脉也脉弦。此外，由于病人体质的差异，化寒化热亦有所不同。故弦数者多见有热；脉弦迟者，则多见有寒。因此，在治疗上也应有所区别，不能混而不分。如疟脉弦而小紧，紧主里主实，是疟病兼有饮食积滞之邪，治宜泻下胃肠之积；若疟脉弦而迟，为疟病兼见寒邪的反映，则可用温中散寒之法；若疟脉弦紧而不

弦细，是疟病兼有风寒之邪，宜用针灸发汗之法；若疟病脉见浮大，知其邪在高位，可以吐而越之，而因势利导；若脉弦而数，乃疟病阳热内盛，可用清热之法治之；若阳热内盛，则阴伤动风，而成“风发”之变，可从饮食方面酌情调理，如饮以梨汁、蔗汁，甘寒而生津，以息其风则愈。

本条的特点是从脉象以论病，以及因证制宜的各种设想和治法，寓有凭脉辨证的意义。

【选注】

《金匱要略心典》：“疟者少阳之邪，弦者少阳之脉，有是邪，则有是脉也。然疟之舍，固在半表半里之间，而疟之气，则有偏多偏少之异。故其病有热多者，有寒多者，有里多而可下者，有表多而可汗、可吐者，有风从热出而不可以药散者，当各随其脉而施治也。徐氏曰：‘脉大者为阳，小者为阴，紧虽寒脉，小紧则内入而为阴矣。阴不可从表散，故曰下之愈。迟既为寒，温之无疑。弦紧不沉，为寒脉而非阴脉，非阴故可发汗针灸也。疟脉概弦，而忽浮大，知邪在高分，高者引而越之，故可吐。’喻氏曰：仲景既云弦数者多热矣，而复申一义云：弦数者风发，见多热不已，必至于极热，热极则生风，风生则肝木侮土，而传其热于胃，坐耗津液，此非可徒求之药，须以饮食消息，止其炽热，即梨汁、蔗浆生津止渴之属，正《内经》风淫于内，治以甘寒之旨也。”

2.病疟，以月一日发，当以十五日愈；设不差，当月尽解；如其不差，当云何？师曰：此结为癥瘕，名曰疟母，急治之，宜鳖甲煎丸。

鳖甲煎丸方

鳖甲十二分，炙 乌扇三分，烧 黄芩三分 柴胡六分 鼠妇三分，熬 干姜三分 大黄三分 芍药五分 桂枝三分 葶苈一分，熬 石韦三分，去毛 厚朴三分 牡丹五分，去心 瞿麦二分 紫葳三分 半夏一分 人参一分 廔虫五分，熬 阿胶三分，炙 蜂窠四分，炙 赤消十二分 蜣螂六分，熬 桃仁二分

上二十三味，为末，取煅灶下灰一斗，清酒一斛五斗，浸灰，候酒尽一半，着鳖甲于中，煮令泛烂如胶漆，绞取汁，内诸药，煎为丸如梧子大，空心服七丸，日三服。

《千金方》用鳖甲十二片，又有海藻三分，大戟一分，廔虫五分，无鼠妇、赤消二味，以鳖甲煎和诸药为丸。

【词解】

癥瘕：腹中结块，形坚不变，叫做癥；时聚时散，无物有形的，叫做瘕。

疟母：疟久不解，而肝脾肿大，胁下气血成块，按之坚而痛的，叫做“疟母”。

【论解】

本条是论述疟母的证治。病疟以月计之，一日而发，当十五天愈。何以见之？以五日为一候，三候为一气，一气为十五天。人受气于天，而息息相通，所以，天气更则人身之气亦更，更而气旺，则不受邪而自愈。设病不愈，当月尽则解，乃是又更一旺气。如是，已更二气，而其病仍不愈者，此乃疟邪不衰，内与肝脾气血搏结，形成癥瘕，而名曰疟母。母者老也，言疟有形而势已甚，故当急治以消其癥。如拖延日久，则正衰邪实而无能为力矣，治用鳖甲煎丸。

鳖甲煎丸活血破瘀，调和营卫。方中鳖甲入肝，软坚消结，除邪养正，合煅灶灰浸酒以祛瘀消积而为主药；大黄、芒硝、桃仁、桂枝泻血中之热，破瘀血，通气滞；蜣螂、廔虫、蜂窠协助硝黄桃仁而消坚破瘀；紫葳、牡丹活血行血，以去血中伏热；乌扇、葶苈开痹利肺，合石韦、瞿麦以清利湿热之结；人参、阿胶、芍药补气养血，扶正以和营卫；柴胡、黄芩、桂枝、干姜、半夏、厚朴理肝胆之气，调治寒热而运化痰湿。诸药相配，活瘀消癥，攻补兼施，寒热并调，共奏消癥散瘕，驱除疟邪之功。

【选注】

《医宗金鉴》：“病疟者，以月计之，如一日发者，当以十五日愈，以十五日更一气也。人受气于天，天气更则人身之气亦更，更气旺，则不受疟邪，故愈也；设若不差，当月尽解，是又更一旺气也。倘如更二气不差，此疟邪不衰，与病者气血痰饮，结为癥瘕，名曰疟母也，当急治之，宜用鳖甲煎丸攻之可也。”

《张氏医通》：“此方妙用全在鳖甲之用灰淋酒煮如胶漆，非但鳖甲消积，酒淋灰汁亦善消积，较疟母丸之用醋煮，功用百倍。”

《金匱玉函要略辑义》：“此方合小柴胡、桂枝、大承气三汤，去甘草、枳实，主以鳖甲，更用以上数品，以攻半表之邪，半里之结，无所不至焉。”

【病案举例】

张姓，男，34岁。两年来患三日疟，反复发作。今夏，病发至秋，病尚未愈。形体消瘦，面色萎黄，肢体无力，脘闷腹胀，饮食不佳，脾肿大，肋下4厘米。疟来先恶寒怕冷，随即发热，体温38℃上下，两小时后汗出热退。脉象稍弦，舌苔薄白。邪在少阳留恋不解，痰湿内蕴，气滞血瘀，结于右胁。治当先截其疟，后治其痞，方拟鳖甲汤加减。处方：鳖甲15克，柴胡、黄芩、半夏各10克，常山、槟榔、草果各6克，生姜3片，大枣2枚。于疟发前服药。服药三剂，疟发停止。随用鳖甲煎丸，以治其癥结。每日服鳖甲煎丸30克，分三次服。连服两月，疟未发作，脾肿大缩小为肋下2厘米。再服鳖甲煎丸一个月，疟发根本控制，脾肿大缩小为1厘米。形体渐壮，饮食增加，病已痊愈，嘱常服鳖甲煎丸，以消余症，防其再发。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,7:1）

3.师曰：阴气孤绝，阳气独发，则热而少气烦冤，手足热而欲呕，名曰瘧疟。若但热不寒者，邪气内藏于心，外舍分肉之间，令人消铄肌肉。

【词解】

阴气：指津液精血等物质。

阳气：指邪热与功能亢盛而言。

烦冤：胸中烦闷不舒。

外舍：邪气藏留于外。

分肉：一指皮内近骨之肉，与骨分者；一指肌肉。前人称肌肉外层为白肉，内层为赤肉，赤白相分，叫分肉。

消铄：热邪伤叫烁，肌肉夺叫消，铄同烁。

【诠解】

本条论述瘧疟的病因、症状和病理变化。疟病，一般指定时的或冷或热症状，此乃正邪往来相争的一种反映。由于疟邪内蕴于心，外舍分肉之间，内外邪热亢盛，耗阴灼津，消烁肌肉，手足发热。热伤正气，则少气而烦冤。热伤胃阴，胃中不安，故欲呕吐。阴气亏损，阳气独盛，故但热无寒，名曰“瘧疟”。瘧，热也，故俗称“热疟”。

本证治疗，可用白虎加人参汤或竹叶石膏汤，或用梨汁、甘蔗汁甘寒以养阴。

【选注】

《金匱要略心典》：“夫阴气虚者，阳气必发，发则足以伤气而耗神，故少气烦冤也。四肢者，诸阳之本，阳盛则手足热也。欲呕者，热干胃也。邪气内藏于心者，痺为阳邪，心为阳脏，以阳从阳，故邪外舍分肉，而其气则内通心脏也。消烁肌肉者，肌肉为阴，阳极则阴消也。”

4.温症者，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕，白虎加桂枝汤主之。

白虎加桂枝汤方

知母六两 甘草二两，炙 石膏一斤 粳米二合 桂去皮，三两
上剉，每五钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，汗出愈。

【词解】

疼烦：疼得很重的意思。

【论解】

本条论述温症的证治。此证温热内蕴，热盛于里，故身无寒而但热。热伤于胃，其气上逆，则时时作呕。热邪内蒸，腠理不固，复感外寒，而留于关节，故关节疼烦。“其脉如平”，指温症之脉而不弦，其脉而如平也。本证是症热内盛，兼见表寒，为热多寒少之温症，以资与痺症互相区别。治以白虎加桂枝汤，内则清热生津，外则解表散寒。内热清则呕止，表寒散则骨节疼烦愈。

温症和痺症均属热盛之证，但又有区别。温症是里热兼外寒留于关节，以身热时呕，骨节疼烦为主，故用白虎加桂枝汤清内热，解表邪。痺症是阴气孤绝，阳气独发，以但热无寒，少气烦冤，手足发热欲呕，消烁肌肉为主，故用白虎加人参汤或竹叶石膏汤清热益气生津。由此可知，温症病情较轻，痺症则较重。另外，白虎加桂枝汤方后注有“温服汗出愈”，可以理解，温症虽然热甚，但多无汗，或者汗出不彻，表邪尚未宣透，这是与痺症的不同之处。

【选注】

《金匱要略心典》：“温症者，邪气内藏肾中，至春夏而始发，为伏气外出之证，寒蓄久而变热，故亦不作寒也。脉如平者，病非乍感，故脉如其平时也。骨节烦疼时呕者，热从肾出，外舍于其合而上并于阳

明也。白虎甘寒除热，桂枝则因其势而达之耳。”

【病案举例1】

石姓，女，38岁。间日疟10天，疟发5次。先见微寒，旋即高热，体温40℃，口渴思饮，心烦多汗，甚则谵语，周身关节酸痛，脉象洪数，舌苔干黄，发热3~5小时后，汗大出热解，病乃《金匱》温疟，邪在三阳。治以白虎加桂枝汤加减。

处方：石膏40克，知母12克，甘草4克，桂枝6克，柴胡12克，黄芩10克，常山6克，甜茶6克。

服药要在疟发两小时之前，连服3剂，疟即停止发作。后与和解少阳法调治，以防反复。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,9:19）

【病案举例2】

张某，女，32岁。初产妇九日，下地外出，感受风寒，突然发生寒战，耸动有力，继之则上身汗出烦热不堪，而下身无汗。自觉寒冷彻骨，口中干渴，时时索水。视其人缘缘面赤，舌色红绛，附有一层薄白苔，脉浮按之则大。余问曰：头痛否？答曰：痛在左。又问，恶风否？答曰：在背。

综其脉证，合而观之，此证为内有伏热，值生产之后，血弱气尽，受如持虚，风邪因入而为病。阳郁于上，不周于下，则下肢反冷；里热伤津，故而渴欲饮水；新邪束表，则背反恶寒，而脉又浮。

处方：桂枝6克，白薇10克，玉竹10克，生石膏30克，知母10克，甘草6克，粳米一大撮。

服药仅一剂，病霍然解。

（刘渡舟治验）

5.疟多寒者，名曰牡疟，蜀漆散主之。

蜀漆散方

蜀漆洗去腥 云母烧二日夜 龙骨等分

上三味，杵为散，未发前以浆水服半钱。温疟加蜀漆半分，临发时服一钱匕。一方云母作云实。

【词解】

牡疟：寒气痰饮之邪伏于心间，而不能外透，故症见多寒，甚则只寒无热。心为“牡脏”，故曰牡疟。

【诠解】

本条论述牡疟的证治。此疟少热多寒，因无形之寒气挟有形之痰饮，伏于心间，阳气不能外透于肌表，故热少寒多，或但寒无热，心阳被遏，称为牡疟。

治以蜀漆散，祛痰截疟，助阳扶正。方中蜀漆祛痰截疟，涌吐痰浊而发越阳气，为治疟主药；龙骨镇静安神，收敛津液，以制蜀漆上越之猛；云母性温，祛痰化湿；浆水和胃，又助蜀漆以吐顽痰。诸药相因，驱逐阴邪，宣发阳气，则牡疟可愈。

服用本方时，在病发之前（1~2小时）用浆水服药。如服之过早则达不到疗效，服药过迟则疟又发作，而更加躁扰，故服药在未发前为恰好。另外，为了避免服药后的呕吐，可以把蜀漆醋制或水炒为好。

【选注】

《张氏医通》：“邪气内藏于心，则但热而不寒，是为瘧疟；邪气伏藏于肾，故多寒而少热，则为牡疟。以邪气伏结，则阳气不行于外，故外寒；积聚津液以成痰，是以多寒，与《素问》少阴经证之多热少寒不同。方用蜀漆和浆水吐之，以发越阳气；龙骨以固敛阴津；云母从至下而举其阳，取山川云雾开霁之意。盖云母即阳起石之根，性温而升，最能祛湿运痰，稍加蜀漆，则可以治太阴之湿疟。方后有云：湿疟，加蜀漆半分，而坊本误作温疟，大谬。”张氏之注，聊备一格，以供参考。

附《外台秘要》方

牡蛎汤

治牡疟。

牡蛎四两，熬 麻黄去节，四两 甘草二两 蜀漆三两

上四味，以水八升先煮蜀漆、麻黄，去上沫，得六升，内诸药煮取二升，温服一升。若吐，则勿更服。

【诠解】

本方尤在泾云：此系宋孙奇等所附，盖亦蜀漆散之意，而外攻之力较猛矣。赵氏云：“牡蛎软坚消结，麻黄非独散寒，且可发越阳气，使通于外。结散阳通，其病自愈”。

【选注】

《金匱要略论注》：“牡疟概由邪扰心包，使君火不能外达，故以牡蛎之咸寒软坚散结，兼能安肾而交心者为君，仍以蜀漆吐其邪，而加麻黄、甘草，以助外达之势。”

柴胡去半夏加栝楼汤

治疟病发渴者，亦治劳疟。

柴胡八两 人参 黄芩 甘草各三两 栝楼根四两 生姜二两 大枣十二枚

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日二服。

【词解】

劳疟：疟病日久不愈，而正气伤者，叫“劳疟”。

【诠解】

本条是论用柴胡去半夏加栝楼根汤易治疟病发渴和劳疟日久不愈的治疗方法。徐忠可认为：“疟邪亦在半表里，故入而与阴争则寒，出而与阳争则热，此少阳之象也……所以小柴胡亦为治疟主方。渴以半夏易栝楼根，亦治少阳成法也。攻补兼施，故亦主劳疟”。方中柴胡、黄芩和解少阳，而透邪清热；人参、甘草、生姜、大枣补脾生津，调和营卫，护正拒邪；栝楼根生津润燥，清热止渴。因本方有补养气阴的作用，故又可治日久不愈的“劳疟”。

【选注】

《张氏医通》：渴者阳明津竭，而所以致阳明津竭者，本少阳木火之势劫夺胃津而然，故疟邪进退于少阳，则以小柴胡进退而施治也。至于劳疟之由，亦木火盛而津衰致渴，故亦不外是方也。”

柴胡桂姜汤

治疟寒多微有热，或但寒不热。服一剂如神。

柴胡半斤 桂枝三两，去皮 干姜二两 栝楼根四两 黄芩三两 牡蛎三两，熬 甘草二两，炙

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。初服微烦，复服汗出便愈。

【诠解】

疟病者，夏伤暑热，营阴被损，又与秋日感受凉风，卫阳被伤有关。营卫两伤，阴阳失调，故寒多热少，或但寒无热。

治以柴胡桂姜汤。桂枝和太阳之表，干姜温太阴之里，栝楼根生津滋液，软坚和阴；柴胡疏利肝胆，以解少阳之邪；黄芩清胆以肃三焦之热；甘草和中，而调和阴阳。本方服后微烦是阳复的机转，为药已中病。复服汗出则三焦通达，气行津布自愈。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“是疟也，以寒多言之，若与牡疟相类，以药论之，则非也。牡疟邪客心下，此风寒湿痹于肌表。肌表行阳以温分肉，痹则阳气不得通于外，遂郁伏于荣血之间，半表半里之分也。阳化气热，血滞成瘀，著于其处，遇卫气行阳二十五度及之则病作。其邪之入荣者，既无外出之势，而荣之素痹者，亦不出而与阳争，故少热或无热也。是用柴胡为君，发其郁伏之阳，佐以桂枝、干姜，散其肌表之痹；栝楼根、牡蛎为臣，除留热，消瘀血，佐以黄芩助柴胡，治半表里；甘草以和诸药，调阴阳也。得汗则痹邪散、血热行而病瘥耳。”

【病案举例】

王某，40岁，1980年5月16日初诊。寒热往来，寒多热少，隔日而发。吐痰甚多，口苦，胸闷，心悸，泄泻，小便短少，舌苔薄白，脉弦细。此为寒疟。宜柴胡桂枝干姜汤加味：柴胡10克，桂枝10克，干姜10克，黄芩10克，栝楼根12克，甘草10克，煅牡蛎30克，草果12克，槟榔10克，青陈皮各10克，茯苓12克，白术12克，常山6克。

5月21日复诊：服前方2剂，寒热已净。吐白涎甚多，心悸，梦多，舌白，脉浮缓。是血不足而心阳衰弱，宜桂枝加龙骨牡蛎汤加味。

川桂枝10克，白芍12克，炙甘草10克，生姜10克，红枣12枚，龙骨30克，牡蛎30克，枣仁12克，远志6克，干姜6克，茯苓12克，五味子6克，细辛6克，生白术12克。

5月31日三诊：病邪已去，惟体虚贫血，脉细弱，舌淡白，其余眠食尚佳，可与归脾汤调理之。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,8:8）

结语

本篇论述了疟病的脉证、病机和治疗。将疟病的辨证分为瘧疟、温疟、牡疟、疟母、寒湿疟、劳疟、营卫两伤疟。如但热不寒的瘧疟，宜清热生津，用白虎加人参汤或竹叶石膏汤治之；热多寒少的温疟，宜清热生津，解散表邪，用白虎加桂枝汤治之；寒多热少的牡疟，宜祛痰通阳，用蜀漆散主之；疟病经久不愈，深入血络，结成癥瘕的叫“疟母”，治宜活血化瘀，调和营卫，用鳖甲煎丸主之；若牡疟兼寒湿甚者，可用牡蛎汤，发越郁结之阳，祛痰而消饮；疟病发渴，或久成“劳疟”，可用柴胡去半夏加栝楼汤，补脾生津，解热润燥；疟病营卫两伤，寒多热少，或但寒不热，可用柴胡桂姜汤，温通阳气，气化津液，调和肝脾阴阳。

中风历节病脉证并治第五

概说

本篇是论述中风、历节等十余种疾病的辨证论治。本篇重点论述了中风和历节病的证治，也论述了瘾疹、胸满短气、癰痼、狂、头风、脚气、痿痹、眩晕、厉风等病的辨证论治。篇中共有条文十条，载方十二首，其中包括附方五首。本篇从第一条至第三条为中风病的发病机理、脉证和鉴别诊断。第四条至第七条，以及第九条阐述历节病的病理、脉证。第八条、第九条则论历节病的有关证治。其他如风痹等几种病证的证治在附方中分别叙述。由于中风、历节等十余种疾病，多属风邪或湿邪引起的疾患，多有四肢不能正常活动的病证，故合为一篇讨论。

中风病又名卒中，因外感风邪，或因发病急骤，病证多端，有风性善行而数变的特征，故称中风。症状多见突然昏倒，丧失神志，然后出现半身不遂、口眼喎斜等。关于中风的病因，有外风、内风、虚风等分。外风是指风寒燥火等邪从外侵入以后，或动内风，或助痰火，或痹经络，而成中风病证。内风如是痰火内发，因火热既能动风，又能炼液成痰，痹阻脉络，而成中风之病。虚风是指血虚生风，或脉络空虚，风邪乘虚而入，留着为痹，乃成中风之病。中风的病机，是经络血脉痹阻不通，气血不能畅行，筋脉失养，故有半身不遂、口眼喎斜等。至于痹证是指风寒湿三气杂至，痹于肌肉或关节，症状有肌肉关节疼痛、重着、麻木等证候。

历节病多见疼痛遍历关节，病势发展较速。病因先有肝肾不足，而后风寒湿邪侵入机体，留于关节，发生关节肿大疼痛等证。

1.夫风之为病，当半身不遂，或但臂不遂者，此为痹。脉微而数，中风使然。

【词解】

风之为病：指中风病而言。

不遂：不能随意运动。

痹：指中风的病机，在于经脉痹阻。

【诠解】

本条是论述中风的辨证。中风病人的正气先虚，卫阳不足，故脉来微弱。阴血不足，则肝风易动，风燥化火，或五志化火，故脉又数。火热灼液为痰，瘀阻经脉，闭塞不通，气血不能畅行，筋脉失养，故病变轻的出现一臂偏废；病变较重的，则一侧肢体不能随意运动，而成偏瘫。

【选注】

《张氏医通》：“半身不遂者，偏风所中也；但臂不遂者，风遂上受也。风之所客，凝涩荣卫，经脉不行，分肉筋骨俱不利，故曰此为痹。今因风着为痹，荣遂改微，卫遂改数，盖微者阳之微，数者风之炽也。”

《医门法律》：“臂不举为痹，叙于半身不遂之下，谓风从上入臂先受之，所入犹浅也。世传大拇一指独麻者，三年内定中风，则又其浅者矣。”

2.寸口脉浮而紧，紧则为寒，浮则为虚，寒虚相搏，邪在皮肤。浮者血虚，络脉空虚，贼邪不泻，或左或右，邪气反缓，正气即急，正气引邪，**喎**僻不遂。邪在于络，肌肤不仁；邪在于经，即重不胜；邪入于府，即不识人；邪入于藏，舌即难言，口吐涎。

【词解】

寸口：指左右两手寸关尺脉。

贼邪不泻：贼邪，指伤害人体的邪气，如风邪、寒邪等。不泻，指邪气留于经络血脉，而不能排出。

喎僻：就是口眼**喎**斜。

即重不胜：是指邪入于经，就有肢体重滞，不易举动之证。

【诠解】

本条是论述中风的病因、病机及辨证方法。由于气行脉外，血行脉中，阴血亏损，阳气独亢，外似盛而内实虚，故此脉浮主络脉空虚，风寒之邪，乘虚侵袭，故紧则为寒。由于正虚不能抗邪外出，故贼邪留而不泄。受邪之侧，脉络气血受伤则经络缓而不用，故面肌松弛，运动无力。不邪之处即受正气支配的一侧，则正气独治而紧急；于是，正气引

邪，则面肌反见拘急，故出现^𦣻僻不遂。

中风的辨证，病变较轻者，是邪中络脉，营气不能运行于肌表，以致肌肤麻木不仁。病变较重者，是邪中经脉，经脉阻滞，气血不能运行于肢体，以致肢体重滞不易举动。病势更重，是邪中于腑，胃腑不能输泻，湿浊郁蒸，神失清灵，故不识人。病势最重，是邪中于脏，邪气归心，乱其神明，故舌纵难言，津液失摄，口中吐涎。

【选注】

《金匱要略心典》：“寒虚相搏者，正不足而邪乘之，为风寒初感之诊也。浮为血虚者，气行脉外而血行脉中，脉浮者，沉不足，为血虚也。血虚则无以充灌皮肤，而络脉空虚，并无以捍御外气，而贼邪不泻，由是或左或右，随其空处而留着矣。邪气反缓，正气即急者，受邪之处筋脉不用而缓，无邪之处正气独治而急，缓者为急者所引，则口目为僻，而肢体不遂，是以左^𦣻者邪反在右，右^𦣻者邪反在左。然或左或右，则有邪正缓急之殊，而为表为里，亦有脏腑经络之别。经云：经脉为里，支而横者为络，络之小者为孙；是则络浅而经深，络小而经大，故络邪病于肌肤，而经邪病连筋骨，甚而入腑，又甚而入脏，则邪递深矣。盖神藏于脏而通于腑，腑病则神窒于内，故不识人。诸阴皆连舌本，脏气厥不至舌下，则机息于上，故舌难言而涎自出也。”

侯氏黑散

治大风，四肢烦重，心中恶寒不足者。《外台》治风癰。

菊花四十分 白术十分 细辛三分 茯苓三分 牡蛎三分 桔梗八分 防风十分 人参三分 矾石三分 黄芩五分 当归三分 干姜三分 芎^劳三分 桂枝三分

上十四味，杵为散，酒服方寸匕，日一服。初服二十日，温酒调服，禁一切鱼肉大蒜，常宜冷食，六十日止，即药积在腹中不下也，热食即下矣，冷食自能助药力。

【词解】

大风：古代证候名称。

本方是论述中风挟寒证治准则。由于病人气血亏损，虚阳上越，阳热炼液为痰，所以常见面红、眩晕、昏迷。又感大风寒邪，阻滞经脉阳

气，故四肢烦重，半身不遂。阳气不足，风寒邪气向内，渐欲凌心，故心中恶寒不足。

治以侯氏黑散，清肝化痰，养血祛风。方中菊花、牡蛎、黄芩清肝潜阳；桔梗涤痰通络，矾石排除痰垢，以治眩晕昏迷；人参、茯苓、当归、川芎、白术、干姜温补脾胃，补气养血，活血通络；防风、桂枝、细辛散风寒邪气，温通阳气，治四肢烦重，半身不遂等。

【选注】

《金匱要略编注》：“直侵肌肉脏腑，故为大风，邪困于脾，则四肢烦重；阳气虚而风未化热，则心中恶寒不足，故用参、术、茯苓健脾安土，同干姜温中补气，以菊花、防风能驱表里之风，芎^芎宣血养血为助，桂枝引导诸药而开痹着，以矾石化痰除湿，牡蛎收阴养正，桔梗开提邪气，而使大气得转，风邪得去，黄芩专清风化之热，细辛祛风而通心肾之气相交，以酒引群药到周身经络为使也。”

3.寸口脉迟而缓，迟则为寒，缓则为虚。荣缓则为亡血，卫缓则为中风。邪气中经，则身痒而瘾疹，心气不足，邪气入中，则胸满而短气。

【词解】

亡血：亡是亡失，血是营血。

瘾疹：即风疹块等一类疾患，因风湿郁于肌表所引起。又可解为时发时止的皮疹。

心气不足：是指心之气血不足。

入中：指风邪内入，伤中心肺。

【论解】

本条是论述瘾疹和胸满两种风病的辨证。由于营血不足，脉至而无力，故曰缓则为虚，为亡血。由于卫气不足，气之行不及，故曰迟则为寒，营卫两虚易受外邪，则为中风。此乃邪中浅表，而尚未中经。若风邪中经，则气血欲行不能行，汗湿欲透不得透，风湿郁在皮表，可发生风疹，而身体奇痒。若心气不足，风邪乘虚内传心肺，使胸中气机不利，则胸胁胀满而短气。

【选注】

《金匱要略悬解》：“寸口脉迟而缓，迟则为血气之寒，缓则为营卫之虚，荣缓则为里虚而亡血，卫缓则为表虚而中风。邪气中于经络，

风以泄之，而卫气愈敛，闭遏营血不得外达，则身痒而瘾疹，痒则气欲行而血不行也。血郁外热发于汗出之外，则成红斑。卫气外敛不能透发，红点隐见于皮肤之内，是为瘾疹。营气幽郁不得畅泄是以身痒，若心气不足，邪气乘虚而入，壅遏中气，则胸胁胀满而短气不舒也。”

风引汤

除热瘫痫。

大黄 干姜 龙骨各四两 桂枝三两 甘草 牡蛎各二两 寒水石 滑石 赤石脂 白石脂 紫石英 石膏各六两

上十二味，杵，粗筛，以韦囊盛之。取三指撮，井花水三升，煮三沸，温服一升。治大人风引，少小惊痫瘈瘲，日数十发，医所不疗除热方。《巢氏》云：脚气宜风引汤。

【词解】

瘫痫：瘫是指半身不遂，痫是指癫痫。

韦囊：古代用皮革制成的药袋。

【诠解】

本方是论述风邪内进，火热内生，五脏阳亢病风的辨证论治。由于风热内侵，或盛怒不止，脏气亢甚，血热进心，上逆于头，故面红、目赤、神志昏迷。气血不行于四肢，故瘫痪不能运动。热伤阴血，不能滋养筋脉，故抽搐。热盛则炼液成痰，故见惊风癫痫。

凡是五脏火热炽盛，血热上升，引起中风瘫痪、癫痫、小儿惊风等病。皆可用风引汤，清热降火，镇惊息风。方中大黄、桂枝泻血分实热，引血下行，通行血脉，为除热瘫痫的主药；滑石、石膏、寒水石、紫石英、赤石脂、白石脂潜阳下行，清金伐木，利湿解热，龙骨、牡蛎镇惊安神，固敛肝肾；干姜、甘草温暖脾胃，和中益气，且佐诸石之寒。

【选注】

《金匱要略论注》：“风邪内并则火热内生，五脏亢甚进归入心，故以桂甘龙牡通阳气安心肾以为君，然厥阴风木与少阳相火同居，火发必风生，风生必挟木势侮其脾土，故脾气不行，聚液成痰，流注四末，因成瘫痪，故用大黄以荡涤风火湿热之邪为臣，随用干姜之止而不行

者，以补之为反佐，又取滑石、石膏清金以伐其木，赤白石脂厚土以除其湿，寒水石以助肾水之阴，紫石英以补心神之虚为使，故大人、小儿风引惊痫皆主之。”

【病案举例】

郑某，女，49岁，1980年11月17日初诊。患者高血压已5年，血压波动在160~230/95~130毫米汞柱之间，经常头痛、眩晕，服过多种降压西药，但效果不显。1980年11月6日心电图检查：窦性心律，Q-T间期延长0.44秒（最高值0.42秒）；眼底检查：视网膜血管痉挛；X线提示：主动脉弓突出；尿常规：蛋白（+），红细胞少数。近一周来，头痛、眩晕加剧，手足麻木，面红，口苦，耳鸣，便秘，溲赤，舌质红，舌苔薄黄，脉象弦硬稍数，血压180/110毫米汞柱。诊为肝火上炎，肝阳上亢，肝风有欲动之势。治宜泻肝火，平肝阳，息肝风，用风引汤加减。

处方：寒水石12克，紫石英30克，生石膏18克，生龙骨、生牡蛎各30克，生石决明20克（均先煎半小时），滑石14克（包煎），赤芍15克，干姜3克，大黄9克，川芎10克，地龙10克，钩藤12克（后下），菊花10克，黄芩10克。水煎服。一日1剂，分2次服。

3剂后头痛眩晕大减，便通溲清，黄苔消退，脉见缓象，血压170/100毫米汞柱。药症合拍，初见成效。原方加灵磁石30克，干姜增至6克再进。血压逐渐下降，服药至12月4日血压正常，头痛、眩晕消失，已可自由行走，惟舌头尚感不太灵活。原方去寒水石、磁石、大黄，加菖蒲10克、葛根10克。至12月30日诸症皆失。前后共服风引汤加减39剂，后易避风降压丸常服，以善其后。追访1年，血压一直正常。

（摘自《中医杂志》1982,12:25）

防己地黄汤

治病如狂状妄行，独语不休，无寒热，其脉浮。

防己一分 桂枝三分 防风三分 甘草一分

上四味，以酒一杯，渍之一宿，绞取汁；生地黄二斤^㕮咀，蒸之如斗米饭久；以铜器盛其汁，更绞地黄汁，和分再服。

【词解】

妄行：指行为反常。

独语：独自一人胡言乱语。

咬咀：此处作把药切碎解。

【论解】

本方是论述血虚火盛的风病辨证论治。由于心肝阴血亏损，不能滋潜风阳，形成肝风上扰，而心火炽盛。风热上扰，神识错乱，故病如狂状，而脉来浮大。又因风升而气涌，气涌而痰逆，痰浊上聚于心，则精神昏乱，故独语不休。身无寒热，不见表证，脉浮，是阳气外盛之象。

治用防己地黄汤，滋阴降火，养血息风，透表通络。方中生地黄汁用量最大，补阴血，益五脏，养血息风，滋阴降火；桂枝、防风、防己透表散热，通络去滞；甘草益阴泻火。

【选注】

《金匱要略编注》：“盖热风邪入于心，风火相搏，神识躁乱不宁，故如狂状妄行。而心主语，风火炽盛于心，独语不休，经谓心风焦绝善怒吓是也。风邪入内，表无寒热，但脉浮耳。此少阴时令感冒风火入心，是为温热病之制，非治中风之方，乃编书者误入。然中风证非四肢不收，即喎僻半身不遂，何能得其狂状妄行？读者详之。因心经血虚，火盛受风，故用生地凉血养血为君，乃取血足风灭之意，甘草以和营卫，防风、防己驱风而使外出也。”

《金匱要略论注》：“此亦风之进入于心者也。风升必气涌，气涌必滞涎，滞涎则留湿，湿留壅火，邪聚于心，故以二防、桂、甘去其邪，而以生地最多，清心火凉血热，谓如狂状，妄行独言不休，皆心火炽盛之证也。况无寒热，则知病不在表，不在表而脉浮，其为火盛血虚无疑耳。后人地黄饮子、犀角地黄汤等，实祖于此。”

【病案举例】

陈某，女，41岁。诸关节酸痛一年余，屈伸不利，经常咽痛，舌苔薄，脉濡，血沉95毫米/小时，给予祛风胜湿清热的防己地黄汤加味治疗：木防己15克，羌活30克，桂枝9克，生地15克，生甘草9克，蒲公英30克，防风9克，西河柳30克。共治疗18天，关节酸痛消失，咽痛亦除，复查血沉降至5毫米/小时。

（摘自《新中医》1980,2:36）

头风摩散方

大附子一枚，炮 盐等分

上二味为散，沐了，以方寸匕，已摩拭上，令药力行。

【诠解】

本方是论头风的外治法。由于气血虚弱，脉络涩滞，风寒之邪袭于头面，经络引急，凝涩不通，故多见偏头作疼，或兼口眼^喎斜等。

治以头风摩散。先用温水沐洗患处，再用散药摩其患处。方中附子辛热力雄，以散风寒之热，又能温通血脉，以缓经络拘急；食盐咸寒，渗透络脉，引邪外出。

【选注】

《张氏医通》：“头风摩散治中风^喎僻不遂，专取附子以散经络之引急，食盐以治上盛之浮热，《千金》借此治头面一切久伏之毒风也。”

4.寸口脉沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即为肾，弱即为肝，汗出入水中。如水伤心，历节黄汗出，故曰历节。

【词解】

如水伤心：如果水湿之邪伤了心和血脉。

黄汗：指历节病中关节溢出黄水的证候。

【诠解】

本条是论述历节的病因、病机和脉证。历节病人，肝血肾气不足，肝血虚则脉弱，筋脉不强，肾气虚则脉沉，骨骼不坚。筋骨不强的病人，在汗出腠理开泄之时，又入水中，寒湿内侵，伤及血脉，浸淫筋骨，流入关节，气血不能运行，郁为湿热，故周身关节皆痛，痛处肿大，溢出黄水，故名历节。

【选注】

《金匱要略心典》：“此为肝肾先虚而心阳复郁，为历节黄汗之本也。心气化液为汗，汗出入水中，水寒之气从汗孔侵入心脏，外水内火，郁为湿热，汗液则黄，浸淫筋骨，历节乃痛。历节者，遇节皆痛也，盖非肝肾先虚，则虽得水气，未必便入筋骨，非水湿内侵，则肝肾虽虚，未必便成历节。仲景欲举其标而先究其本，以为历节多从虚得之。”

5.趺阳脉浮而滑，滑则谷气实，浮则汗自出。

【词解】

趺阳脉：是指足背动脉，足阳明胃经冲阳穴，可候胃气的变化。

【诠解】

本条是论述饮酒之人胃有湿热，容易外感寒湿成为历节病。由于酒湿之邪在胃，使谷气不消而成实，所以脉滑。内热外蒸而腠理开泄，故脉又见浮。浮主热，胃热则汗自出。若汗出入水中，或汗出当风，寒湿内侵，郁为湿热，可以成为历节病。

【选注】

《金匮要略论注》：“此既言历节因风湿，其在胃在肾不同，而皆因饮酒汗出当风所致，乃历节病之因于风者也。谓趺阳脾胃脉也，滑为实，知谷气实，浮为热盛，故汗自出；然谷何以不行而实，岂非酒湿先伤之乎？胃何以致热，岂非风搏其湿乎？”

6.少阴脉浮而弱，弱则血不足，浮则为风，风血相搏，即疼痛如掣。

【词解】

少阴脉：手少阴脉在神门穴，可以候心气。足少阴脉在太溪穴，可以候肾气。

【诠解】

本条是论述血气虚弱，风邪外侵历节病的病机。由于血气不足，故少阴脉弱。风邪乘虚而入，故少阴脉浮。风邪袭入，化热耗伤营血，不能营养筋骨，筋脉燥急，故关节抽掣疼痛，不得屈伸。本证治法，当以养血活血，清散风热为主。

【选注】

《医宗金鉴》：“李彰曰：风在血中，则慄悍劲切，无所不至，为风血相搏。盖血主营养筋骨者也，若风以燥之，则血愈耗而筋骨失所养，故疼痛如掣。昔人曰：治风先养血，血生风自灭，此其治也。”

《金匮要略论注》：“若少阴脉左尺也，主肾主阴，弱则阴不强，故知血不足；肾脉本沉，无故而浮，故知为风。风血相搏，而邪与正争，故疼痛如掣，有似抽掣也。然风何以得至少阴，岂非因酒湿挟风而乘之乎。”

7.盛人脉涩小，短气自汗出，历节疼，不可屈伸，此皆饮酒汗出当风所致。

【词解】

盛人：身体肥胖的人。

【诠解】

本条是论述历节病的病因和病机。病人阳气不足，湿气较盛，所以短气。阳气不固，所以自汗出。汗出则腠理空虚，又饮酒出汗，腠理大开，风邪侵入，与湿邪相合，流入关节，阻碍气血运行，所以脉涩小，关节疼痛不可屈伸。

【选注】

《金匮要略论注》：“若盛人，肥人也。肥人湿多，脉得涩小，此痹象也。于是，气为湿所搏而短，因风作而使自汗，气血为邪所痹，而疼痛不可屈伸，然肥人固多湿，何以脉骤涩小，岂非酒湿困之乎？何以疼痛有加而汗出不已，岂非湿而挟风乎？脉证不同，因风则一，故曰：此皆饮酒汗出当风所致。”

8.诸肢节疼痛，身体尪羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。

桂枝芍药知母汤方

桂枝四两 芍药三两 甘草二两 麻黄二两 生姜五两 白术五两 知母四两 防风四两 附子二两，炮

上九味，以水七升，煮取二升，温服七合，日三服。

【词解】

尪羸：是指身体瘦弱。《脉经》作“魁瘰”，是形容关节肿大之状。

脚肿如脱：是指两脚肿大，如脱离身体的样子。

温温欲吐：泛恶欲吐不吐的形状。

【诠解】

本条是论述风湿历节的辨证论治。风寒湿邪侵入机体，邪留关节，痹阻阳气，气血不畅，故肢节肿大疼痛；湿阻中阳，故温温欲吐；流注下焦，故脚肿如脱；若湿热上蒸而耗气伤阴，故头目眩晕而短气。至于身体尪羸，乃为耗气伤阴正虚之候。

治以桂枝芍药知母汤，温阳行痹，驱除风寒湿三邪。方中桂枝、麻黄发散风寒之邪；白术去湿；附子散寒；防风散风；生姜、甘草和中止吐；芍药、知母滋阴清热，以御燥药伤阴之偏。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“此风寒湿痹其荣卫、筋骨、三焦之病。头眩短气，上焦痹也；温温欲吐，中焦痹也；脚肿如脱，下焦痹也；诸肢节疼痛，身体尪羸，筋骨痹也……然湿多则肿，寒多则痛，风多则动，故用桂枝治风，麻黄治寒，白术治湿，防风佐桂枝，附子佐麻黄、白术；其芍药、生姜、甘草亦和发其荣卫，如桂枝汤例也。知母治脚肿，引诸药祛邪益气力，附子行药势为开痹大剂。然分量多而水少，恐分其服而非一剂也。《三因方》云：每服四钱。”

【病案举例】

石姓，女，34岁。患类风湿关节炎半年。风寒湿热杂至，风胜则游走疼；湿胜则关节肿；寒胜则剧痛；热胜则发热。故病形体消瘦，手足小关节渐渐粗大，活动不便，大关节游走疼痛无定，痛甚时，如虎噬痛不可忍，低热不尽，脉象细滑，舌红苔白。病情复杂，治极棘手。方选

桂枝芍药知母汤，祛风散寒，除湿清热兼治。

处方：桂枝10克，赤芍12克，甘草6克，麻黄6克，生姜5片，白术10克，知母12克，防风9克，附子12克。

加减连服50剂，关节疼痛基本控制，低热退尽，行走活动自如，体形渐壮，病邪已经衰退。原方加补气养血药调治，以防病情反复。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,9:19）

9.味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄。咸则伤骨，骨伤则痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰断泄。荣气不通，卫不独行，荣卫俱微，三焦无所御，四属断绝，身体羸瘦，独足肿大，黄汗出，胫冷，假令发热，便为历节也。

【词解】

泄：是指筋伤弛缓不收。

枯：指骨伤痿软不任。

断泄：指肾精枯竭，肝血虚少，则生气不续，谓之“断泄”。

四属：指四肢，或指皮、肉、脂、髓而言。

【论解】

本条是论述过食酸咸，内伤肝肾所致的历节病。人食五味，可以养人，如味有偏嗜，或有不及，则可以致病。如过食酸则伤肝、伤筋，筋伤则弛缓不用，不能随意运动，所以谓之“泄”；过食咸则伤肾、伤骨，骨伤则痿弱不能行立，所以谓之“枯”。过食酸咸味，损伤肝肾，则精竭血虚，谓之“断泄”。肝肾俱伤，气血亦因之而衰弱，营卫气血不能治于三焦，则肢体得不到营养，而日渐羸瘦。湿浊流注于下，所以两脚肿大，关节疼痛，疼处渗出黄汗，为湿郁发热，属于历节病。

若全身黄汗出，肿胀，胫冷，无痛楚，是为黄汗病。这是作者自注之词，以资与历节鉴别。

【选注】

《金匱要略心典》：“此亦内伤肝肾，而由于滋味不节者也。枯泄相搏，即筋骨并伤之谓。曰断泄者，言其生气不续，而精神时越也。营不通因而卫不行者，病在阴而及于阳也。不通不行，非壅而实，盖即营卫涸流之意。四属，四肢也。营卫者，水谷之气，三焦受气于水谷，而四肢禀气于三焦，故营卫微则三焦无气，而四属失养也。由是精微不化于上，而身体羸瘦，阴浊独注于下，而足肿胫冷黄汗出，此病类似历节、黄汗，而实非水湿为病。所谓肝肾虽虚，未必便成历节者是也。而

虚病不能发热，历节则未有不热者，故曰：假令发热，便为历节。后《水气篇》中又云：‘黄汗之病，两胫自冷，假令发热，此属历节’。盖即黄汗、历节而又致其辨也。”

10.病历节不可屈伸，疼痛，乌头汤主之。

乌头汤方

治脚气疼痛，不可屈伸。

麻黄 芍药 黄芪各三两 甘草炙 川乌五枚，**咬**咀，以蜜二升，煎取一升，即出乌头

上五味，**咬**咀四味，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中，更煎之，服七合，不知，尽服之。

【诠解】

本条是论述寒湿历节的辨证论治。由于寒湿侵袭于关节，凝结不去，阻碍气血，所以关节疼痛，强急不可屈伸。寒邪为病，故脉象沉紧。

治以乌头汤散寒止痛。方中麻黄发散风寒之邪；乌头温通阳气，驱寒止痛；芍药、甘草缓解拘急，通络和阴；黄芪益气扶正，以补卫虚。然乌头辛热有毒，又恐难以驾驭，故用白蜜之甘润，以缓其毒性，使邪去而不伤正。本方能使寒湿凝滞之邪，微微汗出而解，为峻药缓用之法。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“此汤概治历节不可屈伸疼痛，于方下又复言治脚气疼痛，必仲景书历节条下有方而无药石，见脚气中方名同而有药，集书者遂两出之，且二病皆因风寒伤于筋，麻黄开玄府，通腠理，散寒邪，解气痹；芍药以理血痹，甘草通经脉而和药；黄芪益卫气，气壮则邪退；乌头善走，入肝筋逐风寒；蜜煎以缓其性，使之留连筋骨，以利其屈伸，且蜜之润，又可益血养筋，并治乌头燥热之毒也。”

《金匱要略心典》：“此治寒湿历节之正法也。寒湿之邪，非麻黄、乌头不能去，而病在筋节，又非如皮毛之邪，可一汗而散者，故以黄芪之补，白芍之收，甘草之缓，牵制二物，俾得深入而去留邪。”

【病案举例】

韩姓，女，34岁。患风湿性关节炎，关节剧痛，发热，痛甚则肿，游走不定，中药用过越婢汤、白虎加桂枝汤、麻黄加术汤、上中下通用痛风方；西药用过祛风湿药、激素，发热已经控制。但周身关节游走疼痛肿胀，手足不能屈伸，剧痛时烦躁不安，1日哭泣3~4次，有时非注射杜冷丁则痛不解。舌淡苔白，脉象弦紧。《金匱》云：“病历节不可屈伸，疼痛，乌头汤主之。”

处方：麻黄6克，赤芍12克，甘草6克，黄芪10克，制川乌3克，白蜜30克。服两剂，痛似有缓解。原方川草乌改为生川、草乌各5克，加细辛4克，服3剂痛大减，手足屈伸自如。药已见效，当重剂续进。生川、草乌改各6克，细辛改5克，再服3剂，疼痛基本控制。但服药后舌麻木不仁，1~2小时后消失，此为乌头轻度中毒症状。原方剂量减轻再服。处方：生川、草乌各5克，麻黄5克，白芍12克，甘草6克，黄芪12克，细辛4克，白蜜30克（冲）。

加减30余剂，疼痛消除，行动自如。原方加减，出院调治。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,9:20）

按语：上方治“脉管炎”疼痛欲死者，亦有较好的疗效。

矾石汤

治脚气冲心。

矾石二两

上一味，以浆水一斗五升，煎三五沸，浸脚良。

【诠解】

本方指出脚气冲心的辨证论治。人之阳气虚弱，不能运化水湿，水湿毒气伤于下，留滞不去，郁蒸成热，上冲于心，故下肢肿大，麻痹不仁，屈伸不利，而心悸不安。

治以矾石汤。矾石酸涩性燥，能却水收湿解毒，毒解湿收，则不冲心，脚肿自消。

【选注】

《金匱要略编注》：“然脚气因风湿、寒湿、湿热所致。经云：伤于湿者，下先受之，阴病者，下行极而上。因上、中二焦之气先虚，脾湿下流，相招外邪，互蒸成热，上冲于心，即地气加天之谓也。故用矾

石味酸性温，煎汤淋洗，善能收湿澄浊，清热解毒；然湿从下受，当使下渗而去，则不冲心矣。”

附方

《古今录验》续命汤

治中风痲，身体不能自收，口不能言，冒昧不知痛处，或拘急不得转侧。姚云：与大续命同。兼治妇人产后去血者，及老人小儿。

麻黄 桂枝 当归 人参 石膏 干姜 甘草各三两 芎^芎一两 杏仁十四枚

上九味，以水一斗，煮取四升，温服一升，当小汗，薄复脊，凭几坐，汗出则愈，不汗更服，无所禁，勿当风。并治但伏不得卧，咳逆上气，面目浮肿。

【词解】

痲：是指四肢不痛，废而不收，无论偏废、全废都称痲。

冒昧：是指精神恍恍惚惚，郁冒蒙昧。

【诠解】

本方是论述中风偏枯的辨证论治。因为营血素虚，风寒侵入，痹阻营卫，营卫不能行于外，所以身体不能自收持，或拘急不得转侧；营卫不得行于内，故冒昧不知痛处，口不能言。

治以续命汤散邪补虚。方中麻黄、桂枝散风寒，行营卫；石膏、杏仁清肃肺气，肺气宣达则使营卫畅行内外；人参、甘草、当归、川芎补气养血，通调营卫；干姜温胃以助药力。

【选注】

《金匱要略心典》：“痲者，废也。精神不持，筋骨不用，非特邪气之扰，亦真气之衰也。麻黄、桂枝所以散邪，人参、当归所以养正，石膏合杏仁助散邪之力，甘草合干姜为复气之需，乃攻补兼行之法也。”

《千金》三黄汤

治中风手足拘急，百节疼痛，烦热心乱，恶寒，经日不欲饮食。

麻黄五分 独活四分 细辛二分 黄芪二分 黄芩三分

上五味，以水六升，煮取二升，分温三服。一服小汗，二服大汗。心热加大黄二分，腹满加枳实一枚，气逆加人参三分，悸加牡蛎三分，渴加栝楼根三分，先有寒加附子一枚。

【词解】

心热：指胃肠实热积滞。

【诠解】

本方是论述中风偏枯，风寒深入，郁而化热的证治。病人营卫素虚，外感风寒邪气，故恶寒，手足拘急，百节疼痛。风寒外闭，阳气内郁而化热，则烦热心乱，经日不欲饮食。

治以三黄汤，散寒清热，补益卫虚。方中麻黄、独活、细辛散深入之风寒湿邪，温经络行营卫，黄芩清热燥湿，黄芪补卫气以杜风邪。方后注有心热、腹满、气逆、悸、渴等证的治法。由于湿热内郁，胃肠内有实热积滞，所以常见腹满、便秘，或见大便黏滞而臭，故加大黄泻实热，加枳实行气消满。湿热郁于胃，胃气上逆，加人参补脾胃之气，以运化湿浊而降逆气。郁而化热，心热则悸，故加牡蛎安神；肺胃有热阴气伤，加栝楼根养阴清热，肃肺肺气；素有阳虚不温，不御风寒者，则加附子温肾通阳，随证加减，不拘一格。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“亦为中风正治，而少为变通者也。以独活代桂枝，为风入之深者设也。以细辛代干姜，为邪入于经者设也。以黄芪补虚以熄风也；以黄芩代石膏清热，为湿郁于下，热甚于上者设也；心热加大黄，以泄热也；腹满加枳实，以开郁行气也；气逆加人参，以补中益胃也；悸加牡蛎，防水邪也；渴加栝楼根，以肃肺生津除热也……先有寒，即素有寒也，素有寒则无热可知，纵有热亦内真寒外假热而已。云加附子，则方中之黄芩亦应斟酌矣，此仅为虚而有寒者言治也。”

《近效方》术附汤

治风虚头重眩，苦极，不知食味，暖肌补中，益精气。

白术二两 附子一枚半，炮去皮 甘草一两，炙

上三味，剉，每五钱匕，姜五片，枣一枚，水盪半，煎七分，去滓温服。

【诠解】

本方是论述中风入脏，脾肾两虚的证治。由于肾阳不足，寒湿阴邪乘之，邪气上蔽，故头重眩苦极。脾肾阳虚，不能运化水谷精微，浊阴之气停于中，故不知食味。

治以术附汤温暖脾肾。方中附子温暖肾阳，恢复阳和之气，驱散阴寒浊气；白术、甘草、生姜、大枣温暖脾胃，温散寒湿，恢复脾运之机，藉化阴浊之邪。考此证若用轻扬之品，可能引起虚阳上越；若用清疏之品，可能引起脾寒湿停；若用重镇之品，可能引起脾虚下陷。古人立术附一法，温暖脾肾，恢复阳和之气，用治头重苦眩，以示要略之妙。

【选注】

《金匱要略论注》：“肾气空虚，风邪乘之，漫无出路，风挟肾中浊阴之气，厥逆上攻，致头中眩苦至极，兼以胃气亦虚，不知食味，此非轻扬风剂可愈，故用附子暖其水脏，白术、甘草暖其土脏，水土一暖，犹之冬月井中，水土既暖，阳和之气可以立复，而浊阴之气不驱自下矣”。

《医门法律》：“内经谓中风大法有四：一曰偏枯，半身不遂；二曰风痲，于身无痛，四肢不收；三曰风懿，奄忽不知人；四曰风痹，诸痹类风状。后世祖其说而无其治，《金匱》有《古今录验》三方可类推之。经谓内夺而厥则为风痲，仲景见成方中有治外感风邪兼治内伤不足者，有合经意，取其三方，以示法程，一则曰《古今录验》续命汤，再则曰《千金》三黄汤，三则曰《近效》白术附子汤。前一方，治营卫素虚而风入者；中一方，治风热内炽而风入者；后一方，治风已入脏，脾肾两虚兼诸痹类风状者。学者当会仲景意，而于浅深寒热之间以三隅反矣。”

【病案举例】

患者吴某，女，年43岁，自述眩晕已17年，经常发作。发作时，唯静卧而已，稍动则如坐舟中，甚则失去知觉，一日邀余诊治，失慎撞其枕，即感天旋地转，如飘空中，双目紧闭而不敢睁，神志恍惚不清，让其静卧片刻，眩晕稍定，神志逐渐清醒。望其形体虚胖，经日恶寒，脉沉微，舌白而淡。从其脉证来看，证属脾肾阳虚所致，采用《近效》术附汤：附子15克，白术9克，炙甘草6克。嘱其先服一剂，观其疗效。复

诊时，眩晕大减，脉舌俱见起色，继与原方三剂，眩晕基本消失。为了巩固疗效，以八味丸调理，观察半年，未见复发。

（摘自《陕西中医》1981,2:39）

崔氏八味丸

治脚气上入，少腹不仁。

干地黄八两 山茱萸 薯蓣各四两 泽泻 茯苓 牡丹皮各三两 桂枝 附子炮，各一两

上八味，末之，炼蜜和丸梧子大，酒下十五丸，日再服。

【诠解】

本方是论述脚气病的辨证论治。由于肾阳虚弱，不能运化水湿，水湿毒气侵犯于下，随经而上，聚于少腹，故少腹麻木不仁。

治以八味丸，温补肾气，助其气化之权，则阳生湿化，脚气自愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“肾之脉起于足而入于腹，肾气不治，湿寒之气，随经上入，聚于少腹，为之不仁，是非驱湿散寒之剂所可治者，须以肾气丸补肾中之气，以为生阳化湿之用也。”

《千金方》越婢加术汤

治肉极，热则身体津脱，腠理开，汗大泄，厉风气，下焦脚弱。

麻黄六两 石膏半斤 生姜二两 甘草二两 白术四两 大枣十五枚

上六味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。恶风加附子一枚，炮。

【词解】

肉极：是指肌肉极其消瘦而言。

厉风气；古代证候名，可能为近代麻风之病。

【诠解】

本方是论述风气入营，大汗消瘦的证治。风湿邪气侵于肌表，风气入营，气浮化热，肌肉热极汗多，津脱表虚，腠理不固，汗泄不已；津脱血少，营血不行于下焦，故脚弱。风入营为“厉风气”之变。

治以越婢加术汤，清热散风，调和营卫。方中麻黄解散风湿，石膏清热，白术、甘草健脾生津，生姜、大枣调和营卫。本方治汗多而用麻黄，因有白术之补，石膏之清，以制其散而成其治。若汗大泄而有恶风寒证，要防其亡阳，可加炮附子助阳固表。

【选注】

《金匱要略论注》：“此治风极变热之方也。谓风胜则热胜，以致肉极热而汗多，将必津脱，津脱则表愈虚，则腠理不能复固，汗泄不已，将必大泄，风入营为厉。《内经》云：厉者有荣气热腑。今风入营为热，即是厉风气矣。盖风盛气浮，下焦本虚，至厥阳独行而浊阴不降，无以养阴而阴愈虚，则下焦脚弱，故以麻黄通痹气，石膏清气分之热，姜、枣以和营卫；甘草、白术以理脾家之正气。汗多而用麻黄，赖白术之扶正，石膏之养阴以制之，故曰越婢加术汤……汗大泄而加恶风，即防其亡阳，故加附子。”

结语

本篇重点论述中风和厉节两病的病因、病机、症状及治法。中风病的病因，有外因诱发，气血两虚，肝阳上亢，痰浊内发。病机是经脉血气痹阻。辨证当分中络、中经、中腑、中脏，更要详审虚、实、寒、热、痰。本篇还论述了风寒在头的头风病，风湿在皮表的瘾疹，风邪中膈的胸满短气症和风热入营的厉风气等病的辨证论治。中风病的治疗，若属气血亏损，虚阳上越，痰浊与风寒痹阻阳气的，可用侯氏黑散，清肝化痰，和血散风；若属五脏火热炽盛，血热上逆的风、瘫、痫等病，可用风引汤，清热降火，镇惊息风；若属阴血亏损，肝风心火上扰的狂妄等症，可用防己地黄汤，滋阴降火，养血息风；若属风湿在上的中风或偏头痛，可外用头风摩散，温散风寒湿邪；若属血虚外寒的中风偏枯，或痿痺等症，可用续命汤，散邪补虚；若中风偏枯，风寒深入，郁而化热，可用三黄汤散寒清热补卫气；若属风寒入脏，脾肾阳虚，头重眩而不知味的，可用术附汤，温暖脾肾；若风气入营，大汗消瘦的“厉风气”，可用越婢加术汤，清热散风，调和营卫。仅从侯氏黑散、风引汤两张方子的意义，已展示了中风病治外风，治痰火，治血痹，补阴血的治略思想。

关于厉节病的病因，内因方面有肝肾不足，气血两虚，外因方面有汗出入水中，饮酒当风等。但当外邪入侵后，正邪相争，可以寒化，又

可热化。在辨证方面，就可分风湿与寒湿两类。桂枝芍药知母汤治疗风湿历节而兼热；乌头汤治疗寒湿历节而偏虚。以上两方，已扼要地指出了历节病寒热虚实的辨证方法和治疗原则。

与历节病相近的脚气病，有属于阳虚，水湿毒气侵于下的，可用八味丸温肾化湿；若属湿热脚气，上冲于心的，可用矾石汤外洗，解毒收湿，亦能收功。

血痹虚劳病脉证并治第六

概说

本篇是论述血痹和虚劳两病的辨证论治。本篇共有条文十八条，载方十一首，其中附方二首。篇中第一、二条是论血痹病的发病机理、脉证、治法和方药。从第三条至第七条，以及第十条至第十二条是论虚劳病的脉证、发病原因和机理，可作为本篇虚劳病的总论，以下的条文则阐述虚劳病的证治和方药。由于血痹和虚劳两种疾病都是虚证，故合为一篇论述。

血痹是以肌肉麻痹为主证，多因气血不足，感受外邪所引起。血痹证除肢体局部麻木外，往往亦有酸胀和微疼的感觉。它和痹证的筋骨肢体疼痛而迥然有别。

虚劳是慢性的衰弱疾患，包括气虚、血虚、阴虚、阳虚和阴阳两虚等一切证候而言。本篇是以脏腑经络气血阴阳虚损的发病机制为立论根据，并提出了治肾虚调节阴阳，治脾虚调节气血的重要治略思想。

1.问曰：血痹病从何得之？师曰：夫尊荣人骨弱肌肤盛，重因疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风遂得之。但以脉自微涩在寸口，关上小紧，宜针引阳气，令脉和、紧去则愈。

【词解】

尊荣人：指富贵人。

【诠解】

本条是论述血痹病的病因、病机与治疗方法。凡尊荣人，则养尊处优，好逸恶劳，多食肥甘，而肌肉丰盛，不事劳动则筋骨脆弱，以致肝肾虚弱。阳虚则寸口脉微，血虚则寸口脉涩。阳气虚，血行不畅，重因疲劳则汗出，汗出后，体气愈疲，因而嗜卧，卧中不时动摇，此时加被微风遂得而干之，则风寒外束，风与血相搏，则阳气痹阻，血行不畅，故关脉小紧，紧为邪客，微涩为气血不利，治用针刺法，引动阳气。阳

气行则邪去，邪去脉和而不紧，则血痹自愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“阳气者，卫外而为固也。乃因疲劳汗出而阳气一伤，卧不时动摇而阳气再伤。于是风气虽微，得以直入血中而为痹。经云：‘邪入于阴则痹也。’脉微为阳微，涩为血滞，紧则邪之征也。血中之邪，始以阳气伤而得入，终必得阳气通而后出；而痹之为病，血既以风入而痹于外，阳亦以血痹而止于中，故必针以引阳使出，阳出而邪去，邪去而脉紧乃和，血痹乃通。以是知血分受痹，不当独治其血矣。”

2.血痹，阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状，黄芪桂枝五物汤主之。

黄芪桂枝五物汤方

黄芪三两 芍药三两 桂枝三两 生姜六两 大枣十二枚

上五味，以水六升，煮取二升，温服七合，日三服。一方有人参。

【诠解】

本条是论述血痹病的辨证论治。由于营卫气血俱虚，阳气不足，阴血涩滞，又感风寒，故见肢体麻木不仁，即谓之血痹。阳气不足，寸关脉微。外感风寒，故尺中脉小紧，血痹之证以肌肉麻痹为主，如邪重者，亦可发生疼痛；故曰如“风痹”状，而实非风痹之关节流窜疼痛之证。

血痹治疗，可用黄芪桂枝五物汤。方中黄芪益卫气之行；桂枝温经通阳，协黄芪达表，温通血脉；芍药通血脉，而养阴血；生姜、大枣散风寒，补营血，调和营卫。此节与上节合看其义始备，其方即桂枝汤，妙在以黄芪易甘草，倍用生姜载黄芪走表之法。

【选注】

《医宗金鉴》：“此条言阴阳寸口关上俱微，尺中亦小紧，合而观之，可知血痹之脉浮沉，寸口、关上、尺中俱微、俱涩、俱小紧也。微者虚也，涩者滞也，小紧者邪也，故血痹应有如是之诊也。血痹外证，亦身体顽麻，不知痛痒，故曰：如风痹状，但不似风痹历关节流走疼痛也。主黄芪桂枝五物汤者，调养营卫为本，祛风散邪为末也。”

【病案举例】

金某，女，22岁，工人。1976年2月5日初诊。患者一个月前，因用凉水洗衣服，突然发现双手苍白渐即转为青紫，发冷伴有麻木刺疼感，间歇性发作，每次可达数小时，每需双手放入温水中方能缓解。经我院西医外科诊断为“雷诺氏症”。曾使用妥拉苏林、烟酸、消炎痛等效果不佳，乃改用中药治疗。症如上述，舌质淡红，苔白偏厚，脉弦紧。以黄芪桂枝五物汤加减。

处方：黄芪60克，桂枝9克，白芍9克，生姜2片，红花9克，桃仁9克，地龙15克。每日一剂，水煎服。

上方连服二十剂，上述症状已全部消失。原方又服二十剂，病状未见复发。

（摘自《中医杂志》1982,1:72）

3.夫男子平人，脉大为劳，极虚亦为劳。

【词解】

为劳：言其势之将成。

【论解】

本条是论述虚劳病的变化，有阴阳两种病情。虚劳病人阳气不足，阴血亏损，则有阴虚而阳气外浮之机，故见脉浮大按之无力。又有阴阳气血不足，阳气衰惫之象，故轻取则脉象软，重取则脉无力。脉大与脉极虚都是虚劳病的脉象特点，说明肾精损则阴不配阳，故脉大；脾气损则中气不足，故脉虚。先后天阴阳气血亏损是虚劳病辨证论治的纲领。

【选注】

《医宗金鉴》：“男子平人，应得四时五藏平脉，今六脉大而极虚，非平人之脉也。然大而无力，劳役伤脾气也；极虚者，内损肾阴精也。此皆欲作虚劳之候，故有如是之诊也。”

4.男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘悸，脉浮者里虚也。

【词解】

面色薄：面色浅薄不红。

卒喘悸：突然发生气喘心悸。

【论解】

本条是论述虚劳病的辨证。由于心肾阴血不足，血气少而不荣于面，则面色无华，望之浅白，谓之“面色薄”。上条重则论脉，此条重则

论色，合而观之，以见虚劳为病色脉之诊。血气不足，必然津液匮乏，故见口渴，以及亡失血液，所以面色薄也。如其人卒然发生气喘心悸，诊其脉而浮于外，便知其里之虚。夫气虚则喘，血少则悸，而脉又按之无力，如是色、脉、证结合分析，故知其证为虚劳。

【选注】

《金匱要略心典》：“渴者热伤阴气，亡血者不华于色，故面色薄者，知其渴及亡血也。李氏曰：‘劳者气血俱耗，气虚则喘，血虚则悸’。卒者，猝然见此病也。脉浮为里虚，以劳则真阴失守，孤阳无根，气散于外，而精夺于内也。”

5.男子脉虚沉弦，无寒热，短气，里急，小便不利，面色白，时目瞑兼衄，少腹满，此为劳使之然。

【词解】

目瞑：闭上眼睛。此处“目瞑”有眩晕的意思。

【诠解】

本条是论述阴阳两虚的虚劳病。由于肾中真阳不足，精血内虚，故脉虚沉弦；肾虚不能纳气，则呼吸短气；阳虚不能温煦，则腹中拘急；肾阳虚不能气化津液，则小便不利，少腹胀满；肝血虚，则面色白而无华，阴虚不潜，阳热上扰，则目瞑兼衄。

【选注】

《医宗金鉴》：“脉虚沉弦，阴阳俱不足也；无寒热，是阴阳虽不足而不相乘也，短气面白，时瞑兼衄，乃上焦虚而血不荣也；里急，小便不利，少腹满，乃下焦虚而气不行也。凡此脉证，皆因劳而病也，故曰：此为劳使之然。”

6.劳之为病，其脉浮大，手足烦，春夏剧，秋冬瘥，阴寒精自出，酸削不能行。

【词解】

酸削：指两腿酸痛、消瘦。

【诠解】

本条是论述虚劳与四时气候的关系。肾精虚损，虚阳浮于外，所以见脉浮大。阴虚生内热，故手足烦热。春夏木火炎盛，阳气外浮，阴气内伤，故病加剧。秋冬金水相生，阴气得助，阳气内藏，故证候得瘥。但是，秋冬阴寒盛阳气衰，阳虚失于固涩，可能精液清冷而自出。精虚

则肾虚，肾虚则骨弱，故两腿酸痛如削，不能行走。

【选注】

《金匱悬解》：“脉浮大，手足烦者，阳气内虚而外盛也。春夏阳气浮升，内愈寒而外愈热，故剧；秋冬阳气沉降，故热轻而内寒减，故瘥。缘中气虚败，不能交济水火，火炎上热，水渐下寒。肾者，蛰闭封藏之官也。水冷不能蛰藏阳气，则阴寒精自出。水寒不能生发肝木，则酸削不能行也。”

7.男子脉浮弱而涩，为无子，精气清冷一作：冷。

【论解】

本条是论述肾阳不足的虚劳病。由脉浮弱而涩推论病情，可知涩为精血衰少，弱为肾阳不足，浮为虚阳不潜，精气不敛。肾之阴阳精气不足，故精气清冷，所以无子。本证阴阳精气交亏，有阴无阳不能生，有阳无阴不能长，是为“精气清冷”之意。

【选注】

《金匱要略编注》：“此以脉断无子也。男精女血，盛而成胎。然精盛脉亦当盛，若浮弱而涩者，浮乃阴虚，弱为真阳不足，涩为精衰，阴阳精气皆不足，故为精气清冷，则知不能成胎，谓无子也。盖有生而不育者，亦是精气清冷所致，乏嗣者可不知之而守养精气者乎。”

8.夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩一作目眶痛发落，脉极虚芤迟，为清谷亡血失精；脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝龙骨牡蛎汤主之。

桂枝加龙骨牡蛎汤方

《小品》云：虚弱浮热汗出者，除桂加白薇、附子各三分，故曰二加龙骨汤。

桂枝 芍药 生姜各三两 甘草二两 大枣十二枚 龙骨 牡蛎各三两
上七味，以水七升，煮取三升，分温三服。

【词解】

失精家：经常亡失精液的患者。

阴头寒：指男性龟头发凉。

梦交：指女子在梦中与男人交接的证候。

【诠解】

本条是论述阴阳两虚的辨证论治。久患失精病的人，由于肾阴耗损太过，阴虚及阳，肾阳亦虚，阳气不能温煦下焦，气化不利，阴寒凝结，故少腹弦急，阴头寒冷，下利清谷，亡血失精，脉象极虚芤迟。病久精衰血少，故目眩发落。以上脉证，多属元阳衰惫，但也有阳气微浮之象，如脉芤亡血。脉得芤动微紧，芤动说明心火、相火浮而不守，微紧说明阴寒凝结之象仍然存在，故见男子失精，女子梦交，与少腹弦急等。

本证属阴阳两虚，而见元阳衰惫和阳气浮动两种病证。用助阳之法，则有动火之害，如用养阴之法，则又有增寒之弊，故仲景从调和阴阳入手，而用桂枝加龙骨牡蛎汤，调谐阴阳，交通心肾。方中桂枝温通阳气；芍药敛阴缓急；生姜健胃而散阴寒；甘草益中气；大枣补阴血；又加龙骨潜阳，牡蛎敛阴，安肾宁心，固摄精气。务使阴阳相互维系，阳固阴守，则失精自效。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉极虚芤迟者，精失而虚及其气也，故少腹弦急，阴头寒而目眩。脉得诸芤动微紧者，阴阳相乖而伤及其神与精也，故男子失精，女子梦交。沈氏所谓‘劳伤心气，火浮不敛，则为心肾不交，阳泛于上，精孤于下，火不摄水，不交自泄，故病失精；或精虚心相内浮，扰精而出，则成梦交者’是也。徐氏曰：‘桂枝汤外证得之，能解肌去邪气；内证得之，能补虚调阴阳；加龙骨、牡蛎者，以失精梦交为神精间病，非此不足以收敛其浮越也。’”

【病案举例1】

冯某，男，32岁，干部，12月9日门诊。

自谓婚前梦遗失精，婚后房事过度，致患盗汗，迄今年余，屡医不效，多则二三次，至少一次，汗出则醒，醒后潮热，心悸难寐，一寐又汗，惊惕，每晚如此。现头昏目眩，少气腰痛，精神委顿，面色枯黄，舌淡苔薄微干、尖红，唇燥，小便时清时黄，大便时燥时好，六脉轻按浮濡，重按微弱而数，此即《内经》所谓“阴虚者，阳必凑之，故少气，时热，而汗出”之候也。拟滋肾水，调阴阳，兼以潜阳固涩。

处方：桂枝3克，白芍12克，炙甘草、炒枣仁、龟板胶各9克，生熟地各18克，龙骨、牡蛎各15克，生姜3克，大枣5克。水煎服。

二剂后盗汗止，精神好转，五剂后，诸症消失。

（摘自《中医杂志》1979,6:11）

【病案举例2】

患者王某，男，20岁。患失精症，几乎每夜均有，人已疲惫不堪，屡经医治而不见效。余诊其脉弦缓无力，视其舌苔淡嫩不泽。余问有梦否？答曰：始则有，而今已无。辨为脾胃不和，心肾阴阳不交，而精关弛废之证。

处方：桂枝10克，白芍10克，炙甘草6克，大枣12枚，生姜10克，龙骨15克，牡蛎15克。

此方连服5剂，滑精止，人有精神，饮食较佳，从此病愈。

（刘渡舟治验）

天雄散方

天雄三两，炮 白术八两 桂枝六两 龙骨三两

上四味，杵为散，酒服半钱匕，日三服，不知，稍增之。

【诠解】

本方指出虚劳病的治法。天雄散方，以温补阳气为主，收敛精气为佐。方中天雄助阳暖水脏，补腰膝，调血脉，利皮肤；桂枝温通阳气；白术健脾化湿；龙骨收敛精气。本方治疗五劳七伤、阳痿遗精等证，而以白术开源，龙骨节流，天雄固本，三法合一，方意突出。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“天雄散一方，纯以温补中阳为主，以收涩肾精为佐，想为下阳虚甚而上热较轻者设也。”

9.男子平人，脉虚弱细微者，喜盗汗也。

【词解】

喜盗汗：喜当“善”字解，或“多”字体会。

【诠解】

本条是论述阴阳气血俱虚的脉象和盗汗之证。脉象虚细而微弱，是为不足之脉，可知为阴阳气血不足之证。阳气虚而不能固表，阴血虚则不能内守，故容易发生盗汗。盗汗，睡而汗出，阳加于阴，而阴虚不守之证。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“男子平人，为形无病者言也。其形虽不病，而其脉之虚而弱，则阳已损也；细而微，则阴已消也。阳损必驯至于失精，阴耗必驯至于亡血。验其外证，必喜盗汗。阳损斯表不固，阴损而热自发。皆盗汗之由，亦即虚劳之由也。”

10.人年五六十，其病脉大者，痹侠背行，若肠鸣，马刀侠瘕者，皆为劳得之。

【词解】

痹侠背行：指背后脊柱两旁有麻痹感。

马刀侠瘕：结核物生于腋下，名马刀。马刀，长形蚌名，生于颈旁名侠瘕。瘕，同纓，纓帽而有带，结于项间，此处结核，叫“侠瘕”。

【诠解】

本条是论述三种虚劳病的辨证。病人五六十岁而精气衰少，虚阳外浮，虚火上炎，故脉大而中软。卫阳不足，督脉气衰，则脊柱两旁而有麻木痹阻之感。气虚而陷，则肠鸣矢气；或者阴虚阳郁，痰核结于腋下，如“马刀”形，称为马刀。结于颈旁，称为侠瘕。以上三种病，都是属于虚劳病的范畴。

【选注】

《金匱要略心典》：“人年五六十，精气衰矣，而病脉反大者，是其人当有风气也。痹侠背行，痹之侠脊者，由阳气不足而邪气从之也。若肠鸣、马刀、侠瘕者，阳气以劳而外张，火热以劳而上逆。阳外张则寒动于中而为肠鸣，火上逆则与痰相搏而为马刀、侠瘕。”

11.脉沉小迟，名脱气，其人疾行则喘喝，手足逆寒，腹满，甚则溏泄，食不消化也。

【词解】

脱气：元气脱失。

喘喝：疾行时张口喝喝而喘。

【诠解】

本条是论述脾肾阳气亏损的虚劳证。脉来沉小而迟，是脾肾阳气亏损的征象，故名曰脱气。肾阳虚不能纳气，急行则喝喝而喘。肾阳虚，不能温暖四肢，则手足逆寒。肾阳不足，脾阳又衰，脾胃运化功能不足，则饮食不能消化，故见腹满、溏泄等。肾阳虚则生机衰弱，脾阳虚

则气血来源不足，这是一种难于恢复的虚劳病，故名“脱气”，以喻其甚。

【选注】

《医宗金鉴》：“脉沉、小、迟，则阳大虚，故名脱气。脱气者，谓胸中大气虚少，不充气息所用，故疾行喘喝也。阳虚则寒，寒盛于外，四末不温，故手足逆冷也。寒盛于中，故腹满溏泄，食不消化也。”

12.脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革。妇人则半产漏下，男子则亡血失精。

【诠解】

本条是论述脉见芤革，主亡血失精。正如陈修园所注：脉轻按则弦而重按则大；弦则为阳微而迟减；大则为中盛而中芤；减则阳不自振为诸寒；芤则阴不守中为中虚；虚寒相搏，此名为革。革脉不易明，以弦减芤虚二脉形容之，则不易明者明矣。得此脉者，则正气不足，气血虚寒，妇人则主不能安胎而半产，不能调经而漏下；男子不能统血则亡血，不能藏精则失精。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉弦者阳不足，故为减为寒；脉大者阴不足，故为芤为虚。阴阳并虚，外强中干，此名为革，又变革也。妇人半产、漏下，男子亡血、失精，是皆失其产乳生育之常矣，故名曰革。”

13.虚劳里急，悸，衄，腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥，小建中汤主之。

小建中汤方

桂枝三两，去皮 甘草三两，炙 大枣十二枚 芍药六两 生姜三两 胶饴一升

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解，温服一升，日三服。呕家不可用建中汤，以甜故也。

《千金》疗男女因积冷气滞，或大病后不复常，若四肢沉重，骨肉酸疼，吸吸少气，行动喘乏，胸满气急，腰背强痛，心中虚悸，咽干唇燥，面体少色，或饮食无味，胁肋腹胀，头重不举，多卧少起，甚者积

年，轻者百日，渐致瘦弱，五藏气竭，则难可复常，六脉俱不足，虚寒乏气，少腹拘急，羸瘠百病，名曰黄芪建中汤，又有人参二两。

【诠解】

本条是论述脾胃阴阳两虚的辨证论治。脾胃衰弱，阴血阳气来源不足，可发生元阳衰惫，虚阳上浮和营养不足三种病情，表现出阴阳失调、寒热错杂的证象。如偏于寒的，阳气不能温煦，阴血不能濡养内脏，则为里急腹中痛。如偏于热的，阴虚内热，虚阳浮动，则为手足烦热，咽干口燥，衄血，多梦失精。如气血虚少不能濡养肌肉，则为四肢酸疼；血不养心，则为心悸。

由上可知，在阴阳失调的病情中，补阴则碍阳，补阳必损阴，只有用甘温之剂以恢复脾胃的运化功能，脾胃运化正常，则阴阳气血来源充足，则阴阳平衡，营卫和调，而寒热错杂诸症状自然消失。用小建中汤是本治劳以甘之旨，使其温补脾胃，以滋生化之源，内调气血，外调营卫，则阴阳自在其中。方中桂枝辛温通行阳气，温中散寒；饴糖味甘而厚，缓急止疼，合芍药酸甘以化阴，合桂枝辛甘以化阳；芍药味酸，收敛阴血，养荣平肝；甘草甘平，调中益气；大枣补脾滋液；生姜健胃理气。此方调营卫、和阴阳，为何名以建中？曰：中者脾胃也，营卫生成于水谷，而水谷转输于脾胃，故中气立则营卫流行，而不失治疗之意。

【选注】

《金匱要略心典》：“此和阴阳、调营卫之法也。夫人生之道，曰阴曰阳，阴阳和平，百疾不生。若阳病不能与阴和，则阴以其寒独行，为里急，为腹中痛，而实非阴之盛也；阴病不能与阳和，则阳以其热独行，为手足烦热，为咽干、口燥，而实非阳之炽也。昧者以寒攻热，以热攻寒，寒热内贼，其病益甚，惟以甘酸辛药，和合成剂，调之使和，则阳就于阴，而寒以温；阴就于阳而热以和。医之所以贵识其大要也。岂徒云寒可治热，热可治寒而已哉。或问和阴阳、调营卫是矣，而必以建中者何也？曰中者脾胃也，营卫生成于水谷，而水谷转输于脾胃，故中气立则营卫流行而不失其和。又，中者四运之轴而阴阳之机也，故中气立则阴阳相循，如环无端，而不极于偏。是方甘与辛合而生阳，酸得甘助而生阴，阴阳相生，中气自立。是故求阴阳之和者必于中气，求中气之立者必以建中也。”

【病案举例】

曹某，男，11岁。

一诊（1972年7月11日）：腹痛反复发作，已有年余。近日寒热不

已，其腹痛时作时止，大便或泄或干，有时便血，纳谷不佳，面色萎黄，形体消瘦，脉虚软，舌淡无苔。西医外科诊为节段性小肠炎。此为太阴虚寒，营卫失和，脾不摄血。治用小建中汤。

处方：桂枝3克，白芍9克，煨姜3片，红枣5枚，炙甘草3克，饴糖30克（冲）。四剂。

二诊（7月15日）：腹痛已和，便中带血，低热不退，纳谷尚少，脉舌同前。原法不变，增以补气。上方加党参6克，黄芪9克。四剂。

三诊（7月19日）：痛除血止，面色转润，但大便不实，胃纳较差，脉沉，舌淡苔润。此中下虚寒，须温里扶阳，拟附子理中汤加味主之。

处方：党参6克，焦白术9克，姜炭3克，炙甘草3克，陈皮3克，淡附片4.5克，怀山药12克，煨木香3克。五剂。

四诊（7月24日）：大便已调，胃纳亦开，但时有低热起伏，脉细舌淡。仍须以甘温退虚热，再拟小建中汤加味。

处方：桂枝3克，白芍9克，煨姜3片，红枣5枚，炙甘草3克，饴糖30克（冲），党参9克，焦白术9克，云苓9克，怀山药12克。五剂。

药后热退而安。经西医检查，认为病情基本痊愈而出院。

（摘自《中医杂志》1980,12:36）

14.虚劳里急，诸不足，黄芪建中汤主之。于小建中汤内加黄芪一两半，余依上法。气短胸满者，加生姜，腹满者，去枣加茯苓一两半，及疗肺虚损不足，补气加半夏三两。

【诠解】

本条承上条论述阴阳两虚而卫气偏虚的辨证论治。上述之脾胃两虚，营卫气血来源不足，若气虚为甚，形成里虚脉急腹痛，以及眩晕喘喝、失精亡血等，而又见倦怠少气、自汗恶风等，可用黄芪建中汤治疗。

黄芪建中汤，即小建中汤加黄芪，以补脾肺之气，而有益气生津、补气固表止汗之功。若因阳气不能温煦，肺中寒凝气滞，聚湿生痰，引起气短胸满等，则加生姜散饮化痰以理气；若痰湿停于肺中，肺气不降，而生咳逆，则加半夏降逆涤痰；若寒湿凝于脾胃，运化失常，引起腹满，而小便不利，则加茯苓渗湿，以利小便。去大枣之甘，以防其滞腻。本方亦治胃与十二指肠溃疡，如辨证得法，效果颇著。

【选注】

《金匱要略论注》：“小建中汤，本取化脾中之气，而肌肉乃脾之所生也，黄芪能走肌肉而实胃气，故加之以补不足，则桂、芍所以补一身之阴阳，而黄芪、饴糖又所以补脾中之阴阳也。若气短胸满加生姜，谓饮气滞阳，故生姜以宣之。腹满去枣加茯苓，蠲饮而正脾气也。气不顺加半夏，去逆即所以补正也。”

【病案举例】

易某，男，33岁，医生。

1971年4月。患肺结核十余年，反复咯血，经西医抗结核治疗，中医滋阴保肺或金水双培等法治疗，效果均不明显。X线胸片见右上肺大片阴影，密度甚高，左肺及右下肺透亮度增高，诊为：肺硬变，肺气肿。

症见：恶风自汗，心悸短气，面色少华，形体羸瘦，少腹拘急，手足烦热，饮食少进，口燥咽干，溺清便少，脉虚细，前医投月华丸、百合固金汤等皆无显效。证属肺病日久，子盗母气，导致脾胃亏虚，生化无源。投黄芪建中汤加人参：黄芪20克，人参10克，饴糖30克，白芍20克，桂枝7克，炙甘草10克，生姜2片，大枣5枚。

服至10剂诸症见减，饮食增进，精神转佳。效不更方，守方再进，服至30剂时诸症大减，食纳如常人，面色转红润，体重增四斤。服至70剂时各症消失，恢复全日工作。

（摘自《江西中医药》1980,4:63）

15.虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之。方见妇人杂病中。

【诠解】

本条论述肾之阴阳双虚的辨证论治。肾之阴阳两虚，则阴不濡，而阳不煦，气血虚空，故少腹拘急，腰痛膝软，肢冷畏寒。肾与膀胱为表里，若阳不足，则气化无权，故小便为之不利。方用八味肾气丸，补阴之虚以生气，助阳之弱以化阴，阳生阴化，气化乃行，则诸证自愈。

【选注】

《金匱要略直解》：“腰者肾之外候，肾虚则腰痛。肾与膀胱为表里，不得三焦之阳气以决渎，则小便不利，而少腹拘急，州都之官亦失其气化之职，此水中真阳已亏，肾间动气已损，与是方以益肾间之气，气强则便溺行而小腹拘急亦愈矣。”

【病案举例1】

白某，女，26岁。一年来心悸，胸闷，头晕，多汗，口干，腰酸，腿软，血压130/90毫米汞柱，心率120~180次/分，心电图示窦性心动过速，未发现有关器质性变化，诊为交感神经 β 受体功能亢进综合征。此属心肾阳虚，拟金匮肾气汤加减：

熟附子、桂枝、山萸肉、山药、泽泻、生地、丹皮、茯苓各9克。
经治月余，诸证消失。

（摘自《浙江中医杂志》1980,4:182）

【病案举例2】

陈某，女，34岁。

患病已二载，症状为咽喉干燥，而欲频频饮水，然干燥不得解，反而小便增多，尤以夜晚则更甚。尿色清长，量多而畅，除此而又于三五天内，必然发生小腹疼痛，痛时则周身发冷，毛孔粟起，如同感冒风寒之状。

月经正常，惟带下略多。切其脉沉而无力，视其舌苔薄白而润，咽喉未见红肿。

辨证：肾气虚衰，气化不行，水不变津，则咽喉干燥，虚则饮水自救，故而多饮。然饮入之水，不能变化为津液，所以咽喉干燥不解。今阳气衰于下，则阴气独治，是以夜尿多而小腹痛，《内经》云：“三焦膀胱者，腠理毫毛其应”，则小腹痛而又周身发冷亦势所必然矣。病名“肾消”，非八味地黄丸不能愈。共服二斤，则诸证皆瘳。

（刘渡舟治验）

16.虚劳诸不足，风气百疾，薯蓣丸主之。

薯蓣丸方

薯蓣三十分 当归 桂枝 麴 干地黄 豆黄卷各十分 甘草二十八分 人参七分 芎^劳 芍药 白术 麦门冬 杏仁各六分 柴胡 桔梗 茯苓各五分 阿胶七分 干姜三分 白薇二分 防风六分 大枣百枚，为膏

上二十一味，末之，炼蜜和丸如弹子大，空腹酒服一丸，一百丸为剂。

【诠解】

本条论述气血两虚又感风邪的辨证论治。虚劳病人，由于脾胃虚弱，气血不足，则易被风邪所袭，因而肺气闭郁，则心中郁烦，腰酸骨节烦疼；风邪扰于上，则头晕目眩；脾胃虚弱，则食少不化；气血虚损，故少气乏力，羸瘦，惊悸失眠。本证若单纯补益气血则有恋邪于里之弊，若单纯攻邪则又有伤正之虑，必以正邪兼顾之法，才能祛邪而不伤正，扶正而不留邪。薯蓣丸，君以薯蓣健脾益阴，治在扶正；臣以人参、茯苓、白术、甘草、生姜、大枣佐薯蓣健脾以益气；当归、川芎、芍药、干地黄、麦冬、阿胶养血而滋阴；配以柴胡、桂枝、防风祛风而散邪；桔梗、杏仁、白薇则利肺开郁，以行治节；佐以豆卷、神曲运脾气，行药力，有补而不腻之功。

【选注】

《金匱要略论注》：“此不专言里急，是内外皆见不足证，非独里急诸不足也。然较黄芪建中证，前但云里急，故主建中，而此多风气百疾，即以薯蓣丸主之，岂非此丸似专为风气乎。不知虚劳证，多有兼风气者，正不可着意治风气，故仲景以四君、四物养其气血，麦冬、阿胶、干姜、大枣补其脾胃，而以桔梗、杏仁开提肺气，桂枝行阳，防风运脾，神曲开郁，黄卷宣肾，柴胡升少阳之气，白薇化入荣之风。虽有风气，未尝专治之，谓正气运而风气自去也。然薯蓣最多，且以此为汤名者，取其不寒不热，不燥不滑，脾肾兼宜，故以为君，则诸药皆相助为理耳。”

17.虚劳虚烦不得眠，酸枣汤主之。

酸枣汤方

酸枣仁二升 甘草一两 知母二两 茯苓二两 芎^劳二两^{深师有}生姜二两
上五味，以水八升，煮酸枣仁得六升，内诸药煮取三升，分温三服。

【论解】

本条是论述虚烦不眠的辨证论治。由于肝血不足，血燥生热，热扰于心，故心烦而不得眠；虚火上炎，故咽干、口燥、盗汗、头晕目转；血虚则心虚，心虚故心悸。

酸枣仁汤以酸枣仁养肝血、安心神；川芎调肝养血解郁；茯苓、甘草补脾和中，宁心安神；知母滋阴降火，养肺肾之阴，以除烦渴。

【选注】

《金匱要略编注》：“虚劳虚矣，兼烦是挟火，不得眠是因火而气亦不顺也。其过当责心，然心之火盛，实由肝气郁而魂不安，则木能生火，故以酸枣仁之入肝安神最多为君；川芎以通肝气之郁为君，知母凉肺胃之气，甘草泻心气之实，茯苓导气归下焦为佐。虽曰虚烦，实未尝补心也。”

18.五劳虚极，羸瘦腹满，不能饮食，食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络荣卫气伤，内有干血，肌肤甲错，两目黯黑，缓中补虚，大黄廑虫丸主之。

大黄廑虫丸方

大黄十分，蒸 黄芩二两 甘草三两 桃仁一升 杏仁一升 芍药四两
干地黄十两 干漆一两 虻虫一升 水蛭百枚 蛭螬一升 廑虫半升
上十二味，末之，炼蜜和丸小豆大，酒饮服五丸，日三服。

【词解】

羸瘦：身体肌肉消瘦无力。

两目黯黑：有两种解释：一，两眼呈黑黯色；二，两眼视物发黑。应以前解为得休。

【诠解】

本条是论述虚劳内有瘀血的辨证论治。由于食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络荣卫伤，而劳热煎熬，使经络营卫气血运行不

畅，以致内有干血，肌肤不润而如鳞甲之交错；内有干血，气血不能上荣，故两目之色黯黑，瘀血聚于少腹，则少腹硬满，痛而不移，脉多见沉弦涩。

大黄虻虫丸，以大黄、桃仁润血泻瘀；干漆急窜，破瘀逐痹；虻虫、水蛭、蛭螭、虻虫等生物药，实有虫蚁透剔、活血通络之功；芍药、地黄补益肝肾之阴，而有增血行瘀之义；黄芩、杏仁清肺热，利肺气，热去则血不枯，气调则血不停；甘草健脾，调和诸药，以缓中急。

【选注】

《金匱要略直解》：“此节单指干血而言。夫人或因七情，或因饮食，或因房劳，皆令正气内伤，血脉凝积，致有干血积于中，而虚羸见于外也。血积则不能以濡肌肤，故肌肤甲错，不能以营于目，则两目黯黑。与大黄虻虫丸以下干血，干血去，则邪除正旺矣，是以谓之缓中补虚，非大黄虻虫丸能缓中补虚也。”

【病案举例】

石姓，女，19岁。患者16岁月经来潮，18岁初月经渐少，后即经闭不行，形体日渐消瘦，面色**晄**白，饮食减少，精神衰弱，头眩心悸，诸医有从气血虚弱论治常服八珍、归脾汤；有从虚寒论治用温经汤等诸药乱投，月经不行，形体更瘦，少腹拘急不舒。脉象迟涩，舌中有紫斑。病久气血内损，治宜补气养血，但月经不行，瘀血内阻，新血不生，因此治当通瘀破瘀。治仿《金匱》大黄虻虫丸，攻补兼施，汤丸并进，久服方能达到气血恢复，月经通行的目的。

处方：当归、党参、白术、熟地各10克，桃仁、虻虫、红花各6克，甘草4克，大枣5枚，川芎6克。两日服一剂。大黄虻虫丸每服4克，日服3次。原方加减共服两个月，形体健壮，面渐红润，月经已行1次量少。原方既获显效，再服1月，经行正常，病即痊愈。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,7:2）

附方

《千金翼》炙甘草汤

一云：复脉汤 治虚劳不足，汗出而闷，脉结悸，行动如常，不出百日，危急者十一日死。

甘草四两，炙 桂枝 生姜各三两 麦门冬半升 麻仁半升 人参 阿胶各二两 大枣三十枚 生地黄一斤

上九味，以酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，内胶消尽，温服一升，日三服。

【诠解】

本方是论述气血两虚，脉结心悸的辨证论治。脾胃虚弱，气血两虚，血脉不养心，心虚则血行不畅，故脉见结代，而见心动悸。血脉虚燥，不能濡养，故失眠盗汗，咽干口燥，身体瘦弱，大便则干。心血不足，血气不畅，故见胸闷。

治以炙甘草汤，补阴血，通阳气。方中炙甘草益气补中，为和中总司，而化生气血，复脉之本；人参、大枣补气益胃，使气血化生有源；桂枝配甘草通心阳；生姜配白酒通血脉；生地、阿胶、麦冬、麻仁补心血，养心阴，充养血脉。炙甘草汤两补阴血阳气，使心气复而心阳通，心血足而血脉充，则诸证自愈。

【选注】

《金匱要略论注》：“此虚劳中润燥复脉之神方也。谓虚劳不足者，使阴阳不至睽隔，荣卫稍能顺序，则元气或可渐复。若汗出由营卫强，乃不因汗而爽，反得闷，是阴不与阳和也。脉者所谓壅遏营气，令无所避是为脉，言其行之健也。今脉结，是营气不行，悸则血亏，而心失所养，荣气既滞，而更外汗，岂不立槁乎！故虽内外之脏腑未绝，而行动如常，断云不出百日，知其阴亡而阳自绝也。若危急，则心先绝，故十一日死。谓心悬绝，该九日死，再加火之生数，而水无可继，无不死也。故以桂甘行其身之阳，姜枣宣其内之阳，而类聚参、胶、麻、麦、生地润养之物，以滋五脏之燥，使阳得复行于营中，则脉自复。名曰炙甘草汤者，土为万物之母，故既以生地主心，麦冬主肺，阿胶主肝肾，麻仁主肝，人参主元气，而复以炙甘草为和中之总司。后人只喜用胶、麦等，而畏姜、桂，岂知阴凝燥气，非阳不能化耶。”

《肘后》獭肝散

治冷劳，又主鬼疰一门相染。

獭肝一具，炙干末之，水服方寸匕，日三服。

【词解】

冷劳：指寒性虚劳证。

鬼疟：是指传染性的疟病。

【诠解】

本方指出虚劳劳瘵的证治。瘵虫传染于体内，耗竭阳气，损伤阴血。阳气虚弱，故病人食少，倦怠乏力。阴血亏损，故潮热，女子血干经闭。津液不润，故音哑。

本方用獭肝一具，炙干为末，内服。獭肝性温，温阳化阴，可杀瘵虫，而治冷劳。

【选注】

《金匮要略论注》：“劳无不热，而独言冷者，阴寒之气与邪为类，致邪夹寒入肝而搏其魂气，使少阳无权，生气绝，故无不死。又邪气依正气而为病，药力不易及，故难愈。獭者阴兽也，其肝独应月而增减，是得太阴之正，肝与脾为类，故以此治冷劳，邪遇正而化也。獭肉皆寒，惟肝独温，故尤宜冷劳，又主鬼疟一门相染，总属阴邪，须以正阳化之耳。”

结语

本篇是论述由于气血虚损的血痹与虚劳两种疾病。血痹病是由于营卫不足，感受风邪，血行涩滞所引起，症状以肢体局部麻痹为主。可用针刺疗法和黄芪桂枝五物汤，通阳行痹则愈。

虚劳病是由于气血阴阳虚损，正气不足，阴阳失调所引起。至于虚劳的性质，可分为三种：一、元阳衰惫的，则多偏于寒证；二、若虚阳上浮的，则多偏于热证；三、气血不能濡养五脏的，则多见五脏不足之证。虚劳病治疗原则：阴虚的养阴以配阳；阳虚的助阳以配阴；血虚的补血；气虚的补气；若干血成劳，外羸而内实，则用大黄廑虫丸缓中止痛，补虚活瘀；若气血两虚，中气不立，阴阳不和，难于调理的，可用小建中汤，补脾胃之气，化生血液，而缓急止痛，调和阴阳；若阴阳两虚，而心肾不交，则用桂枝加龙骨牡蛎汤调节阴阳，收敛精气。其他如天雄散之补阳；酸枣仁汤之补血；八味肾气丸阴阳两补；薯蓣丸之正邪兼顾；黄芪建中汤治虚劳里急；炙甘草汤治心悸脉结；獭肝散治冷劳等，究其治疗宗旨，皆是“后天之治本血气，先天之治法阴阳”而已。

肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治第七

概说

本篇是论述肺痿、肺痛、咳嗽上气的辨证论治。篇中共有条文十五条，载方十五首，其中包括附方五首。篇中从第一条至第四条为全篇的总论，阐述了肺痿、肺痛、咳嗽上气的成因、病理变化、脉证、治则与转归。第五条、第十条是专论肺痿的脉证治法；第六条至第九条是专论咳嗽上气的脉证与治法；第十三、十四两条则是论述肺胀的证治，第十一、十二、十五三条是论肺痛的脉证与治法。由于这三种病证，都与肺病有关，故合为一篇讨论。

肺痿是肺脏气津不足，肺叶枯萎的病变，然有寒热之分：热性肺痿是肺热气燥，津伤不布，则成肺痿；寒性肺痿是肺寒津凝，气不布津，而成肺痿。肺痿的主要证候表现为咳嗽、咳吐涎沫等。

肺痛，是火毒之邪由气而血伤肺成痛，多属实证。其主要证候，多为咳嗽胸痛，吐脓液浊痰为主。

咳嗽上气，即是咳嗽气喘，亦有虚证实证之分。肺胀是饮邪填塞肺中，咳喘上逆，不能平卧，喉中或有痰鸣声为其特点。

肺痿、肺痛、咳嗽上气三种病证，都关系于肺，轻者使肺气不利而发生咳嗽；重者由气及血，而发生胸痛，咳吐脓血。

1.问曰：热在上焦者，因咳为肺痿，肺痿之病，从何得之？师曰：或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快药下利，重亡津液，故得之。曰：寸口脉数，其人咳，口中反有浊唾涎沫者何？师曰：为肺痿之病。若口中辟辟燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺痛，咳唾脓血。脉数虚者为肺痿，数实者为肺痛。

【词解】

浊唾涎沫：浊唾是浓稠痰，涎沫是稀饮。

辟辟燥：辟者空也。形容口中干燥，津液极少，咳而无痰之状。

【诠解】

本条是论述肺痿、肺痛的病因、证候和鉴别诊断。肺痿病的成因，由于汗出太多；或呕吐频作而伤胃液；或因消渴而津液不滋；或小便利数，而下伤津液；或大便秘结，燥热伤津；或因攻下过度，而重伤津液，如此种种，不一而足。总之，津伤则阴虚，阴虚则生热，热灼肺叶，肺燥火盛，则寸口脉数，热炼津液而为痰，故口中反有浊唾涎沫。

肺痛病是由于湿热火毒聚于肺，壅塞不通，腐肉化脓，故咳唾脓血。邪热在肺，津液不布，则口中干燥；热壅于肺，血脉不利，则胸中隐隐作痛。

肺痿病是燥热伤阴，故脉来虚数。肺痛病是痰热壅塞，故脉数实有力。

【选注】

《医宗金鉴》：“李炆曰：潘^甫甫云：痿与痛，皆热在上焦，其脉皆数，皆咳，亡津液，未有异也。但痿属肺气虚而亡津，虽有热亦不烈，故不致燥涸，虽咳而口中有浊唾涎沫，故脉虽数而虚也；痛则气壅血凝，邪实而热烈，故津液亡而更觉干涸，口中辟辟燥，咳即胸中隐痛，津液既涸，脉应涩滞而反滑数者，蓄热腐脓，脉故数实也。”

2.问曰：病咳逆，脉之，何以知此为肺痛？当有脓血，吐之则死，其脉何类？师曰：寸口脉微而数，微则为风，数则为热；微则汗出，数则恶寒。风生于卫，呼气不入；热过于荣，吸而不出；风伤皮毛，热伤血脉；风舍于肺，其人则咳，口干喘满，咽燥不渴，多唾浊沫，时时振寒。热之所过，血为之凝滞，蓄结痈脓，吐如米粥。始萌可救，脓成则死。

【词解】

脉微：沉取则微而不显，意指浮脉而言。

过：经过。

浊沫：“浊唾涎沫”的简称。

振寒：恶寒而身体振动。

始萌可救：病邪在萌芽时可以挽救。

【诠解】

本条是论述肺痛的病因及其病理变化。肺痛的形成，可以分为三个阶段：一、风热之邪始伤于卫；二、风热之邪，内舍于肺，凡此犹属邪

浅病轻，尚未成为肺痈，故易于治疗，其预后也是良好；三、风热火毒内传荣分，而壅结于肺，邪深病重，则成为肺痈，脓成而不易治疗，其预后则较差。

寸口脉微而数，微，此处指沉取无力，乃浮脉之象，为风中于卫；数脉为热，主热在于内。微为风，风性疏泄则汗出；数为热，内热而外风则反恶寒。风伤于卫，气得风而浮，则吸气不入，故气则呼利而吸难；热过于荣，血得热而壅，则气亦因之不伸，故气吸而不出，此证风伤皮毛虽浅，而热伤血脉则深。风邪从卫入荣，而内舍于肺，结而不散，则使肺气不利而作咳。肺热而壅，则口干喘满；因热在血中，故咽燥而不渴；热邪必逼肺之津液不布，故多唾浊沫；热盛于里而反时时振寒，由是热之所过，则血为之凝滞，蓄结于肺叶而为痈脓，故吐如米粥之脓样物。

【选注】

《医门法律》：“然风初入卫，尚随呼气而出，不能深入，所伤者不过在于皮毛，皮毛者肺之合也，风由所合，以渐舍肺俞，而咳唾振寒，兹时从外入者，从外出之易易也；若夫热过于营，即随吸气深入不出，而伤其血脉矣。卫中之风，得营中之热，留恋固结于肺叶之间，乃致血为凝滞，以渐结为痈脓，是则有形之败浊必从泻肺之法而下驱之，若得其毒随驱下移，入胃、入腹、入肠，再一驱即尽去不留矣，安在始萌不救，听其脓成而致肺叶腐败耶。”

3.上气，面浮肿，肩息，其脉浮大，不治；又加利，尤甚。

【词解】

上气：指气喘。

肩息：指呼吸摇肩，气息困难之状。

【诠解】

本条是论述正虚气脱的上气证。上气面浮肿，摇肩呼吸，气有升而无降。切其脉浮大无根，反映肾不纳气，元阳之根已拔，故为不治。又加下利，则阳脱于上，阴脱于下，离决之象见，故尤甚焉。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“此是较论上气，而非肺痈者也。师意以为肺痿、肺痈无不上气，而亦有非肺痿、肺痈独见上气之证者。总之，上气而浮肿，肩息，脉浮大者，不但肺不制，兼之肾气脱，为不治也；又加下利，脾肾皆脱，为尤甚矣。此明上气证，又与痈痿之上气有别

也。”

4.上气，喘而躁者，属肺胀，欲作风水，发汗则愈。

【诠解】

本条是论述外寒内饮的上气证。由于风寒外束，肺失宣降，水饮内停，肺气壅闭，气机不利，故肺气胀满，上逆而喘，烦躁不安。本证肺气壅闭，不能通调水道，水湿溢于肌表，可能成为风水。肺胀病因，主要是风寒外束，水饮内积，若发汗散风寒，则肺气通畅，肃降得宜，水饮可以解除，而诸证自减。

【选注】

《金匱要略心典》：“上气喘而躁者，水性润下，风性上行，水为风激，气凑于肺，所谓激而行之，可使在山者也，故曰欲作风水。发汗令风去，则水复其润下之性矣，故愈。”

5.肺痿，吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遗尿、小便数。所以然者，以上虚不能制下故也。此为肺中冷，必眩，多涎唾，甘草干姜汤以温之。若服汤已渴者，属消渴。

甘草干姜汤方

甘草四两，炙 干姜二两，炮

上㕮咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

【词解】

不能制下：指肺气不能制约下焦。

服汤已：已，当完了讲。

【诠解】

本条是论述虚寒肺痿的辨证论治。虚寒肺痿，因于上焦阳虚，肺中寒冷，气虚不能敷布津液于诸经，所以多吐涎沫。其人不咳不渴，必遗尿，而且小便亦经常频数，这是上虚不能摄下的证候特点。由于上焦阳气不足，又必见头眩之证。

治以甘草干姜汤温肺气，行津液，制约下焦之阴水。方用甘草、干姜辛甘化阳，以温肺寒。温则润，能行津液，而利阳气，气利则津达，肺得其养，则肺不痿。方有理中之意，具有振中阳、补土暖金之法。

若服甘草干姜汤后，而反口渴者，说明此证已属消渴，则按消渴病治之，不在此例。本条说明虚寒肺痿的治疗要温肺益气，待阳气复，而津液敷布，则唾证自愈，而肺痿可复。

【选注】

《医宗金鉴》：“肺中冷，则其人必不渴，遗尿，小便数，头眩，多涎唾。所以然者，以上焦阳虚，不能制约下焦阴水，下焦之水泛上而唾涎沫，用甘草干姜汤以温散肺之寒饮也。”

【病案举例】

宁某，女，58岁，1968年11月25日诊。有肺结核、气管炎病史已久，经常低热盗汗，咳嗽，近三年来气喘加重，入冬尤甚，经检查确诊为肺源性心脏病。症见：形体消瘦，咳吐白痰，自觉痰凉，咳即遗尿，浸湿衣裤，胸闷气喘，不能平卧，四肢欠温，舌质淡，苔白腻，脉沉细。证属肾阳虚衰，气虚下陷，治以温补肾阳，益气固正。

方用：熟地24克，山萸、山药、陈皮、半夏各12克，丹皮、茯苓各9克，黄芪30克，白术15克，桂枝、附子各4.5克。

三剂后咳喘稍减，但饮食欠佳，余症同前，乃求治于周师。师观其脉证，谓“此乃中阳虚衰，运化无权，土不生金则肺痿，失去肃降之力，不能通调水道，故咳而遗尿，病机为肺中虚冷，阳气不振，上虚不能制下也。乃甘草干姜汤证无疑。”方用：甘草30克，干姜30克，浓煎频服。服药二剂，遗尿、咳嗽减轻，再增甘草为60克，三剂。症状基本控制，继用肾气丸加减调治而愈。

（摘自《浙江中医杂志》1982,1:40）

6.咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。

射干麻黄汤方

射干十三枚 一法三两 麻黄四两 生姜四两 细辛 紫菀 款冬花各三两 五味子半升 大枣七枚 半夏大者洗，八枚一法半升

上九味，以水一斗二升，先煮麻黄两沸，去上沫，内诸药煮取三升，分温三服。

【词解】

水鸡：即田鸡。水鸡声，是形容咳喘的痰鸣声连连不绝。

【诠解】

本条是论述寒饮咳喘的辨证论治。外受风寒，闭塞肺气，水饮内发，痰阻其气，气触其痰，故咳嗽喘急，喉中连连如水鸡之鸣。

治以射干麻黄汤散寒宣肺，开气道之痹。方中麻黄、细辛温经散寒，开肺化饮；款冬、紫菀温肺止咳；半夏、生姜涤痰降逆；射干开利咽喉气道；五味子酸收肺气，以监麻黄、细辛之散；大枣安中扶虚，调和诸药。

【选注】

《医门法律》：“上气而作水鸡声，乃是痰碍其气，气触其痰，风寒入肺之一验耳。发表、下气、润燥、开痰，四法萃于一方，用以分解其邪，不使之合，此因证定药之一法也。”

【病案举例】

王某，女，62岁，初诊日期：1979年5月4日。

病情摘要：肺炎后患咳喘已10多年，1978年冬以来喘咳一直未缓解。上月底感冒后哮喘更甚。

现症：哮喘甚，喉中痰鸣，伴咳吐白痰量多，恶寒背冷，口中和，大便溏泄，日二三行，苔白微腻，脉弦细。听诊两肺满布哮鸣音，左肺有湿啰音。脉证合参，此为外寒内饮，合邪阻肺，治以散寒化饮，化痰降逆，与射干麻黄汤加减：

射干10克，麻黄10克，桑白皮10克，干姜6克，桂枝10克，杏仁10克，炙草10克，冬花10克，半夏10克，五味子10克。

结果：上药服三剂，喘平，咳吐白痰仍多，左肺偶闻干鸣，未闻湿啰音，上方继服6剂，7月17日随访，仅胸闷，吐少量白痰。

（摘自《北京中医学院学报》1981,2:23）

7.咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠，皂荚丸主之。

皂荚丸方

皂荚八两，刮去皮，用酥炙

上一味，末之，蜜丸梧子大，以枣膏和汤服三丸，日三、夜一服。

【词解】

酥：酥油，俗称黄油。

【诠解】

本条是论述痰浊咳喘的辨证论治。由于上焦有热，煎熬津液，形成稠黏的浊痰，阻碍气道，肺金不能肃降，故咳嗽气喘，时时吐出浊痰。痰浊壅盛，吐之不尽，卧则痰上而阻气，呼吸不利，故但坐而不得眠。

本证之痰浊有胶固不拔之势，如不迅速扫除，则痰壅气闭，使人闷绝。治以皂荚丸，皂荚涤痰去垢，扫除痰浊，其力最猛，故饮用枣膏，使其安胃补脾。用蜜为丸者，以制药悍也，又有生津润肺之效。俾涤痰破结而又不伤正，为制方之旨。辨证眼目，在于“但坐、唾浊”四字。

【选注】

《金匱要略心典》：“浊，浊痰也。时时吐浊者，肺中之痰，随上气而时出也。然痰虽出而满不减，则其本有固而不拔之势，不迅而扫之不去也。皂荚味辛入肺，除痰之力最猛，饮以枣膏，安其正也。”

8.咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之。

厚朴麻黄汤方

厚朴五两 麻黄四两 石膏如鸡子大 杏仁半升 半夏半升 干姜二两 细辛二两 小麦一升 五味子半升

上九味，以水一斗二升，先煮小麦熟，去滓，内诸药煮取三升，温服一升，日三服。

【诠解】

本条以脉测证，有外寒与内饮之异，故其治法亦各不同。夫咳而脉浮，则表邪居多，邪在肺家气分，故小青龙汤去桂、芍、草三味，而加厚朴、杏仁利肺以理气；石膏以清热；小麦养心和胃，以扶正气。本方是为有制之师，用药极为巧妙。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：咳者，水寒射肺也；脉浮者，停水而又挟风以鼓之也。麻黄去风散肺逆，与半夏、细辛、干姜、五味子、石膏同用，即前小青龙加石膏汤，为解表行水之剂也。然土能制水，而地道壅塞，则水亦不行，故用厚朴疏敦阜之土，使脾气健运，而水自下泄矣。杏仁下气去逆，小麦入心经能通火气，以火能生土助脾，而共成决

水之功也。”

9.脉沉者，泽漆汤主之。

泽漆汤方

半夏半升 紫参五两 一作紫菀 泽漆三斤，以东流水五斗煮取一斗五升 生姜五两 白前五两 甘草 黄芩 人参 桂枝各三两

上九味，**咬**咀，内泽漆汁中煮取五升，温服五合，至夜尽。

【诠解】

本条继上文而言若咳而脉沉，则里邪居多，为水饮羁縻于肺而不出也。治用泽漆汤逐水通阳，止咳平喘。方中泽漆逐水，消痰之力为猛；桂枝通阳，温化水气；紫菀、白前温肺，止咳平喘；生姜、半夏健胃涤痰散饮；黄芩清肺，除水饮郁生之热；人参、甘草扶正健脾，运化水湿。本方先煎泽漆，汤成之后入诸药，取其逐饮为先，领诸药而治咳逆之气。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：脉沉为水，以泽漆为君者，因其功专于消痰行水也，水性阴寒，桂枝行阳气以导之。然所以停水者，以脾土衰不能制水，肺气逆不能通调水道，故用人参、紫参、白前、甘草补脾顺肺，同为制水利水之方也。黄芩苦以泄之，半夏、生姜辛以散之也。”

10.大逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦门冬汤主之。

麦门冬汤方

麦门冬七升 半夏一升 人参二两 甘草二两 粳米三合 大枣十二枚
上六味，以水一斗二升，煮取六升，温服一升，日三、夜一服。

【词解】

大逆：大为火。“火逆”为津虚火炎，虽咳逆而无痰涎。

【诠解】

本条是论述虚火上炎的咳喘证治。肺胃津液耗损，燥火内盛，虚火上炎，肺中燥热而不得滋润，故见咳逆上气，脉来虚数等。阴液虚少，不润咽喉，故咽喉燥痒不利，或咽中如有物梗，口干欲得凉润，其舌光红少苔。

治以麦门冬汤，清养肺胃，止逆下气。方中重用麦门冬，滋养肺胃之阴液，清降肺胃之虚火；半夏用量极少，为麦冬七分之一，则降逆开结，而疏通津液流行之道；用人参、粳米、甘草、大枣益气养胃，生津润燥。脾胃健运，津液充足，上承于肺，虚火自敛，咳逆上气等证亦可随之消解。此条与泽漆汤治水饮凝结之咳逆相比，而有水咳、火逆之分，并引申下文肺痈之实喘，而又不同矣。文法前后比较，读者须知。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“火逆上气，挟热气冲也，咽喉不利，肺燥津干也。主之麦冬生津润燥，佐以半夏开其结聚，人参、甘草、粳米、大枣概施补益于胃土，以资肺金之助，是为肺虚有热津短者立法也，亦所以预救乎肺虚而有热之痿也。”

【病案举例】

李某，女，75岁，1981年1月22日就诊。

高年形瘦体弱，素来不禁风寒，不耐劳作。稍作外感则每易发热咳嗽，稍有劳累则必定气喘息促。半月前因外感发热咳嗽，未得及时治疗，迁延时日，至今虽外邪自解，但口干咽燥，气喘息促，咳嗽频繁，吐出大量白色涎沫。面色萎黄，纳食少进，口淡乏味，精神疲惫，卧床不起。脉虚缓，舌质淡红少苔。此属肺痿之证，气阴两伤。治拟《金匱》麦门冬汤培土生金，以降冲逆。

处方：麦冬12克，党参12克，制半夏6克，炙甘草10克，大枣7枚，茯苓10克，粳米一把（自加）。

1月25日复诊：服药三剂，纳食增加，口干、咳嗽大有转机，精神好转，已能起床活动。然仍面色萎黄，脉缓右关虚大，苔薄而略干。脾气大虚，胃阴亦伤，再用前方加山药12克、炙黄芪10克。服七剂后，诸症悉除，已能操持家务。

（摘自《浙江中医学院学报》1982,2:25）

11.肺痈，喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。

葶苈大枣泻肺汤方

葶苈熬令黄色，捣丸如弹子大 大枣十二枚

上先以水三升，煮枣取二升，去枣内葶苈，煮取一升，顿服。

【词解】

熬：当炒字解。

【诠解】

本条是论述肺痈在将成未成之初，邪气壅于肺的辨证论治。由于肺痈初起，风热病毒，浊唾涎沫，壅滞于肺，阻碍气机，因而咳喘不能平卧，甚或胸中隐隐作痛。

治以葶苈大枣泻肺汤，乘其始萌一击而去。方中葶苈苦寒滑利，开泄肺气，泻水逐痰；佐以大枣之甘以和药力，而有安胃补脾，补正生津，调和药性的作用。

【选注】

《金匱要略编注》：“风中于卫，血气壅逆，呼气不入，则喘不得卧，因循日久，必致肺叶腐败，吐脓而死，故用葶苈急泻肺实之壅，俾气血得利，不致腐溃吐脓，且以大枣先固脾胃之元，其方虽峻，不妨用之耳。”

12.咳而胸满，振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥样，为肺痈，桔梗汤主之。

桔梗汤方亦治血痹

桔梗一两 甘草二两

上二味，以水三升，煮取一升，分温再服，则吐脓血也。

【诠解】

本条是论述肺痈已经成脓的证治。由于肺痈日久，腐血为脓，故时出浊唾腥臭，或久久吐脓如米粥样的，叫做肺痈。毒热郁于里，而使皮表不固，故脉数而振寒。湿热郁于肺络，肺气不利，故咳而胸满。毒热壅于肺的血分，故咽干而不渴。

治以桔梗汤，为治肺痈之主方，此病为风热所壅，故以桔梗开结排脓；热聚成毒，故用甘草清热解毒。甘草倍于桔梗，其力似乎太缓，实为痈脓已成，正伤毒溃之治法。

【选注】

《金匱要略论注》：“此乃肺痈已成，所谓热过于荣，吸而不出，邪热结于肺之荣分，故以桔梗下其结热，开提肺气，生甘草以清热解毒，此亦开痹之法，故又注曰：再服则吐脓血也。”

【病案举例】

施某，男，17岁。病史摘要：患者憎寒发热一周，咳嗽胸闷不畅，吐少量白色黏痰，查血：白细胞24500/立方毫米，中性85%，X光胸透并摄片报告为：左下肺脓肿。经住院治疗八天，使用大量抗生素，发热不退，遂邀中医诊治，用：桔梗60克，生甘草30克。服药一帖，咳嗽增剧，翌晨吐出大量脓痰，夹有腥臭，原方继进二帖，排出多量脓痰，发热下降，减桔梗为20克，生甘草10克，加南沙参、银花、鱼腥草、生薏仁、瓜蒌皮等，服至10余帖，服尽热退，精神佳，饮食增，胸透复查：脓肿已消散吸收，血象亦正常。

（摘自《江苏中医杂志》1981,3:35）

13.咳而上气，此为肺胀，其人喘，目如脱状，脉浮大者，越婢加半夏汤主之。

越婢加半夏汤方

麻黄六两 石膏半斤 生姜三两 大枣十五枚 甘草二两 半夏半升

上六味，以水六升先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

【词解】

目如脱状：是指两目外鼓，有脱出之状。

【诠解】

本条是论述热饮“肺胀”的证治。由于外感风热，水饮内发，内外合邪，热饮上蒸，填塞肺中，肺气胀满，故咳嗽上气，喘急不得息；喘甚则两目鼓出，而欲脱状。其脉浮大者，为风邪热饮盛于表里，而不解也。

治宜越婢加半夏汤。用麻黄、生姜攻外宣肺，发越水气；石膏清肺中之热，以降肺气；半夏降逆化痰；大枣健脾补中，调和诸药。

【选注】

《金匱要略心典》：“外邪内饮，填塞肺中，为胀，为喘，为咳而上气。越婢汤散邪之力多，而蠲饮之力少，故以半夏辅其未逮。不用小青龙者，以脉浮且大，病属阳热，故利辛寒不利辛热也。目如脱状者，目睛胀突如欲脱落之状，壅气使然也。”

14.肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。

小青龙加石膏汤方《千金》证治同，外更加胁下痛引缺盆

麻黄 芍药 桂枝 细辛 甘草 干姜各三两 五味子 半夏各半升 石膏二两

上九味，以水一斗，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，强人服一升，羸者减之，日三服，小儿服四合。

【诠解】

本条是论述痰饮挟热的“肺胀”证治。由于外感风寒，寒饮内发，内外合邪，郁而生热，故咳而上气，烦躁而喘。脉浮，指此证为风饮，与肺痈证不同。

治以小青龙加石膏汤，外散寒饮，内清烦热，本方介于越婢汤、大青龙汤之间，寒温并进，两不相碍。

【选注】

《金匱要略浅注》：“心下有水，咳而上气，以小青龙汤为的剂，然烦躁则挟有热邪，故加石膏，参用大青龙之例，寒热并进，两不相碍。石膏宜生用，研末，加倍用之方效。”

【病案举例】

李某，男，80岁，1973年夏门诊。哮喘发作旬余，形寒畏冷，时当盛夏，犹着毛线背心，口和不渴，证属寒哮，以发作于暑令，依寒包热证治，径予小青龙加石膏汤原方：麻黄9克，细辛2.4克，五味子9克，干姜3克，炒白芍9克，法半夏9克，甘草6克。服三剂减轻大半，继服三剂，哮喘已获控制。

（摘自《湖北中医杂志》1981,5:7）

附方

《外台》炙甘草汤

治肺痿涎唾多，心中温温液液者。方见虚劳中。

【词解】

心中温温液液：泛恶欲吐之意。

【诠解】

本方指出凉燥肺痿的辨证论治。由于凉燥伤肺，肺虚气乏，不能敷布津液而四达，反聚而成涎，故涎唾为多。肺气虚乏，津液不能流布，化成痰涎，积于膈中，故心中温温液液。

治以炙甘草汤，温润肺气，以行津液。方中人参、炙甘草、生姜、大枣温补脾肺，双补气阴，温润肺气；桂枝温通阳气以行津液；麦冬、生地、麻仁、阿胶滋补阴血，润肺滋燥。

【选注】

《金匱要略方论集注》：“汪双池曰：肺痿者，肺虚气急而肺叶枯萎，此乃清燥之甚，如秋树之枯叶，非由火热，与肺痈大不相似。总有热而咳血者，亦属燥淫所郁之阴火，非实火也，故仲景治肺痿用此汤，及甘草干姜汤。肺枯而反多唾者，肺燥之甚，不能复受津液，则胃气之上蒸者皆化痰涎而已。痰涎积于膈中，津液不复流布，故心中温温液液。”

《千金》甘草汤

甘草

上一味，以水三升煮减半，分温三服。

【诠解】

本方是凉燥肺痿的治法。由于凉燥之气伤于肺，肺叶枯萎，不能敷布津液，故涎唾多。肺痿不能流布津液，津液化为痰涎，积于膈中，故心中温温液液。治用甘草一味，健脾消饮，生津润燥，清肺胃虚热，解毒扶正，故可疗肺痿疾患。

【选注】

《金匱要略论注》：“肺痿之热由于虚，则不可直攻，故以生甘草之甘寒频频呷之，热自渐化也。”

《千金》生姜甘草汤

治肺痿咳唾，涎沫不止，咽燥而渴。

生姜五两 人参三两 甘草四两 大枣十五枚

上四味，以水七升，煮取三升，分温三服。

【诠解】

本方之治是由于脾胃中虚，则使水寒不运，反阻津液不能上滋，以致肺叶枯萎，故吐唾涎沫不止。胸咽干槁无液以滋，则咽燥而渴。

治宜生姜甘草汤，培土生金，滋阴润燥。方中人参、甘草、大枣补脾气，化生津液，润枯泽槁；生姜辛散温通，而暖中宫布散津液。

【选注】

《金匱要略论注》：“此汤即甘草一味方广其法也。谓胸咽之中，虚热干枯，故参、甘以生津化热，姜、枣以宣上焦之气，使胸中之阳不滞而阴火自熄也，然亦非一二剂可以期效。”

《千金》桂枝去芍药加皂荚汤

治肺痿吐涎沫。

桂枝 生姜各三两 甘草二两 大枣十枚 皂荚一枚，去皮子，炙焦

上五味，以水七升，微微火煮取三升，分温三服。

【诠解】

本方是论述气不致津的肺痿证治。由于气寒不温，胸阳不布，而使肺津枯槁，因而成痿。此证吐涎沫，则非无津液，乃是虽得津液而不能收摄与分布耳。

治宜桂枝去芍药加皂荚汤。方中甘草、生姜、大枣温补心肺阳气，而有生津润燥，散寒温肺的功效，桂枝温通胸肺，宣行营卫，合皂荚利涎通窍，以除浊痰。

【选注】

《金匱要略编注》：“用桂枝汤嫌芍药酸收，故去之；加皂荚利涎

通窍，不令涎沫壅遏肺气而致喘痿；桂枝和调营卫，俾营卫宣行，则肺气振，而涎沫止矣。”

《外台》桔梗白散

治咳而胸满，振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥样，为肺痈。

桔梗 贝母各三分 巴豆一分，去皮，熬研如脂

上三味，为散，强人饮服半钱匕，羸者减之。病在膈上者，吐脓血；膈下者泻出；若下多不止，饮冷水一杯则定。

【诠解】

本方是论述湿热火毒肺痈的辨证论治。由于寒痰冷饮壅滞于肺，日久化热而腐溃气血，则见胸满隐痛，咳嗽吐黄痰腥臭，久久吐脓如米粥，成为肺痈。脓成于内，毒气外见，则振寒脉数，寒痰之邪使津液不布，则咽干不渴。

治以桔梗白散泻痰排脓。方中贝母开胸中之郁结，以利巴豆之峻攻，而急破其脓，驱毒外出；桔梗开提肺气，载药上行，以驱尽胸肺之毒。

【选注】

《金匱要略论注》：“此即前桔梗汤证也。然此以贝母、巴豆易去甘草，则迅利极矣。盖此等证危在呼吸，以悠忽遗祸不可胜数，故确见人强或证危，正当以此急救之。不得嫌其峻，坐以待毙也。”

《千金》苇茎汤

治咳有微热，烦满，胸中甲错，是为肺痈。

苇茎二升 薏苡仁半升 桃仁五十枚 瓜瓣半升

上四味，以水一斗，先煮苇茎得五升，去滓，内诸药，煮取二升，服一升，再服，当吐如脓。

【诠解】

本方是论述肺痈的辨证论治。由于湿热内结，痰热瘀血郁结肺中，故咳嗽微热，烦满，吐腥臭黄痰脓血。气滞血凝在肺，不能荣养肌肤，故胸部皮肤粗糙如鳞状。治宜苇茎汤，方中苇茎清肺泄热，利肺滑痰；

薏苡仁利湿排脓，肃肺经毒脓；冬瓜子清化热结，涤脓血浊痰；桃仁活血祛瘀，泻血分热毒。

【选注】

《金匮要略论注》：“此治肺痈之阳剂也。盖咳而有微热，是邪在阳分也；烦满，则挟湿矣；至胸中甲错，是内之形体为病，故甲错独见于胸中，乃胸上之气血两病也。故以苇茎之轻浮而甘寒者，解阳分之气热，桃仁泻血分结热；薏苡下肺中之湿；瓜瓣清结热而吐其败浊，所谓在上者越之耳。”

15.肺痈胸满胀，一身面目浮肿，鼻塞清涕出，不闻香臭酸辛，咳逆上气，喘鸣迫塞，葶苈大枣泻肺汤主之。

方见上。三日一剂，可至三四剂，此先服小青龙汤一剂乃进，小青龙方见咳嗽门中。

【诠解】

本条是论述湿热壅塞于肺成痈，而脓未成的辨证论治。由于痰热火毒，浊唾涎沫，壅塞于肺，气机被阻，故胸满而胀，喘鸣迫塞；肺气壅塞，通调水道失职，则水气泛滥，故一身面目浮肿；肺气不利，不摄津液，故鼻塞流涕，不闻香臭。

葶苈大枣泻肺汤方解见前。

【选注】

《金匮要略直解》：“痈在肺，则胸胀满；肺朝百脉而主皮毛，肺病则一身面目浮肿也；肺开窍于鼻，肺气壅滞，则畜门不开，但清涕渗出，而浊脓犹塞于鼻肺之间，故不闻香臭酸辛也。以其气逆于上焦，则有喘鸣迫塞之证，与葶苈大枣汤以泻肺。”

结语

本篇论述肺痿、肺痈以及咳嗽上气的辨证论治。肺痿有虚热与虚寒两种类型。虚热肺痿可用麦门冬汤，养胃润肺，并清虚火；虚寒肺痿先用甘草干姜汤，温肺复气，以约下焦而布津液。

肺痈要辨脓成与未成，未成脓时，可用葶苈大枣泻肺汤，开泄肺气。若已成脓，时间已久，用桔梗汤排脓解毒而不伤正。至于《千金》苇茎汤，为清泻肺热，兼有逐痰排脓解痈作用，对于肺痈的脓成与未成

均可应用。

咳嗽上气有寒热虚实之分：虚火上炎的咳喘，可用麦门冬汤清养肺胃，止逆下气；痰浊壅盛的咳喘，可用皂荚丸涤痰去垢；外寒内饮的咳喘，可用射干麻黄汤散寒开痹化饮；寒饮上迫的咳喘，可用厚朴麻黄汤温散寒邪，降气化痰；水饮内停的实性咳喘，可用泽漆汤逐水气，止咳平喘。

肺气胀满是因痰饮郁肺而引起，要辨清寒饮与热饮的不同。如热饮填塞肺中，可用越婢加半夏汤，宣肺泄热，降逆平喘；寒饮壅肺，内挟有烦热，可用小青龙加石膏汤，外散寒邪，内清热邪。

奔豚气病脉证治第八

概说

本篇是论述奔豚气病的辨证论治。本篇中的条文共有五条，载方三首。其中第一、二条为奔豚气病的总论，阐述了本病的发病机理和症状。第三、四、五条则为奔豚气病的辨证论治。

奔豚气是指气从少腹上冲咽喉的一种突然发作性疾病。因气冲而急，有似豚之奔跑，故称为奔豚气病。这种病，有因肝而成，或因肾而发等不同。它的证候，以“气从少腹，上冲咽喉，发作欲死，复还止”为其临床特征。

奔豚气病多因惊发激动肝肾之气上冲而成；抑或血不养肝而肝气上冲，以及心阳上虚，水寒之气上犯之所致。

1.师曰：病有奔豚，有吐脓，有惊怖，有火邪，此四部病，皆从惊发得之。

【诠解】

本条论述奔豚气、吐脓、惊怖、火邪四部病，都从惊发得之。惊，由于精神突然受到刺激，而心先受病，心受病若引起肾之水寒之气上凌，则成奔豚气病；若心受病，而及于胃，胃从少阴之火化，则生内痈，而发生“吐脓”；若心病而肝风得少阴之火热而煽动，则可发生“惊怖”；若心病生火，而肾水不能上济，则心火无制而旺，则成“火邪”。由此可见，以上四部病，是皆从惊发得之。然本文论奔豚气病为主，吐脓等则是连类发明。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“凡人心藏神，心安则神安，若因外事猝起惊动其心，则神魂飞越，而为气、为血，俱从之奔越矣。又凡人喜则气开，忧则气敛，怒则气侈，恐则气歉，心既惊动而气血随之，更复气歉，消阻闭藏，遂结聚成病，此奔豚、吐脓、惊怖、火邪四部病之根源

也。”

2.师曰：奔豚病从少腹起，上冲咽喉，发作欲死，复还止，皆从惊恐得之。

【诠解】

本条论述奔豚病的证候和病因。惊恐之变，如思虑易伤心神，恐惧易伤肾志等。神志受伤，则心和肾两脏同病，心火不能下温肾水，肾水不能上滋心火，则心肾水火失调，而下焦水邪之气，则可从少腹如豚之奔，直上冲咽喉，而成奔豚病。奔豚之气上乘于心，则见心惊胆怯，心中烦乱；奔豚气上冲于中，则有腹中胀满，或气满支心，温温欲吐等。奔豚病发作之时，其人有恐怖之感，故有“发作欲死”的记载。随着冲气的下退，而症状也逐渐消失，恢复如常，故曰“复还止”。

本篇第一、第二两条，说明奔豚病有因肝因肾的不同，本条文的精神主要侧重于肾邪上冲之证。

【选注】

《医宗金鉴》：“奔豚者，肾病也，以其病从少腹上冲咽喉，有如豚窜奔突之状，故名之也。发作则肾气上乘于心而欲死，作已则气衰复还于肾而止，故其病虽有微甚不同，然必皆从惊恐得之。盖惊伤心，恐伤肾，两脏交病也。水能胜火，肾上凌心，故治法宜泻肾而补心也。”

3.奔豚，气上冲胸，腹痛，往来寒热，奔豚汤主之。

奔豚汤方

甘草 芎^劳 当归各二两 半夏四两 黄芩二两 生葛五两 芍药二两 生姜四两 甘李根白皮一升

上九味，以水二斗，煮取五升，温服一升，日三、夜一服。

【诠解】

本条论述肝气上逆而作奔豚的证治。由于情志不舒，肝气郁结，化热而动，其气上冲，故为气上冲胸；肝气犯胃，胃气郁滞不通，故见腹痛；肝胆相为表里，肝气为病，则使少阳之气怫郁，故见往来寒热。

治以奔豚汤，疏肝清热，降逆止痛。方中重用甘李根白皮清热降逆；葛根、黄芩清火平肝；川芎、当归、芍药调肝和血；而芍药、甘草

相合又可缓急止痛；生姜、半夏和胃降逆，诸药相配，使肝气条达，则冲气自降，诸证即愈。

本证是肝郁化热引起的奔豚气病，方中重用甘李根白皮清肝火，降冲逆。然李根白皮有催吐作用，故不宜多用。

【选注】

《金匱要略浅注》：“此言奔豚之由肝邪而发者，当以奔豚汤畅肝气而去客邪也。又云：《伤寒论》云：厥阴之为病，气上冲心。今奔豚而见往来寒热腹痛，是肝脏有邪而气通于少阳也。”

【病案举例】

任某，女，28岁，1977年8月初诊。患者二年来闲居在家，心情不佳。近二月来，突然发作气自少腹上冲，直达咽喉，窒闷难忍，仆倒在地，发作数分钟后自行缓解，竟一如常人，每周发作数次，且伴有失眠，多梦，脱发。经各医院检查，未查出阳性病理体征。遂诊断为“癔病”。察舌红苔薄，脉弦细，疑为奔豚气，遵仲景奔豚汤原方：

当归、法半夏各9克，生甘草、川芎、黄芩、白芍、生姜各6克，葛根、李根白皮各12克，水煎服。连进三剂后，其病顿失。随访四年，旧病未再发作。

另治一李姓妇人，与此症相同，亦投以奔豚汤而愈，随访三年，未曾复发。

（摘自《浙江中医杂志》1982,5:225）

4.发汗后，烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上至心，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤主之。

桂枝加桂汤方

桂枝五两 芍药三两 甘草二两，炙 生姜三两 大枣十二枚
上五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升。

【词解】

一壮：是指每烧艾炷一枚，名为一壮。

【诠解】

本条是论述阳气虚弱，阴寒上冲之奔豚病的证治。因太阳病，发汗

不解，又用烧针再发其汗，以致腠理大开，卫阳不固，风寒外入，针处被寒，寒凝血脉，瘀结针孔，故见核起而赤的红硬结块。由于一汗再汗，心阳必虚，内外阴寒相援，故可上凌心阳，而发为气从少腹上冲至心，重则发作欲死。

治以艾炷，外灸其核，温散阴寒，内服桂枝加桂汤，外散寒邪，内泄阴气。方中重用桂枝，助心阳以散阴寒，平冲降逆。本证内外两法同治，共奏温阳散寒、降逆平冲、调和营卫的作用。

【选注】

《医宗金鉴》：“烧针，即温针也，烧针取汗亦汗法也。针处宜当避寒，若不知谨，外被寒袭，火郁脉中，血不流行，所以有结核肿赤之患也。夫温针取汗，其法亦为迅烈矣，既针而营不奉行作解，必其人素寒阴盛也。故虽有温针之火，但发核赤，又被寒侵，故不但不解，反召阴邪，而加针之时，心既虚惊，所以肾水阴邪，得上凌心阳而发奔豚也。奔豚者，肾水阴邪之气，从少腹上冲于心，若豚之奔也。先灸核上各一壮者，外祛其寒邪，继与桂枝加桂汤者，内伐其肾邪也。”

《金匱要略方论本义》：“灸后以桂枝加桂汤主之，意取升阳散邪，固卫补中，所以为汗后感寒，阳衰阴乘之奔豚立法也。与前条心气弛，气结热聚之奔豚，源流大别也。”

【病案举例】

治一崔姓妇女，50岁，患病颇奇，自觉有一股气从内踝沿阴股上窜，行至小腹则胀，抵心胸则气短心悸，头出冷汗；少顷气下行则诸证随减，每日发作两三次，甚为恐怖。其人面色青黄不泽，舌质淡嫩，苔白而润，脉弦数，按之无力。此证中医名“奔豚”，然如此证者实属罕见。且奔豚发作，皆因心阳虚于上坐镇无权，下焦肾之阴邪得以上冲。今阴来搏阳而与之争，故脉虽弦数而按之无力；况弦脉属阴，阴气上逆是以脉弦。当奔豚所过之处，则发胀、憋气、心悸等，亦勿怪其然。舌质淡嫩，则是心阳之虚，治宜助心阳，伐肾降冲，用桂枝加桂汤原方，另服黑锡丹6克，共服五剂，其病不发。

（刘渡舟治验）

5.发汗后，脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

茯苓桂枝甘草大枣汤方

茯苓半斤 甘草二两，炙 大枣十五枚 桂枝四两

上四味，以甘澜水一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。甘澜水法，取水二斗置本盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。

【诠解】

本条是论述心阳不足，水饮内动，欲作奔豚气的证治，由于下焦素有水饮停留，复感风寒，发汗过多，内伤心阳，心阳不能下温肾水，水气欲往上冲，水与气搏，所以脐下筑筑而动悸，此乃欲作奔豚之兆。

治以苓桂甘枣汤，温阳利水，培土渗湿。本方以茯苓、桂枝为主药，温阳化水，交通心肾，泄降冲逆；甘草、大枣和中益气，培土制水。诸药相配，共奏温阳下气，培土伐水之功。

本方与桂枝加桂汤证同属阳虚阴乘所致的奔豚病，两者区别在于有无水饮。桂枝加桂汤证是汗后阳虚，阴气乘虚而上冲，故重用桂枝温阳下气；苓桂甘枣汤证则是汗后阳虚，水饮内动而引起，故重用茯苓健脾利水。

【选注】

《金匮要略直解》：“汗下脐下悸者，阳气虚而肾邪上逆也。脐下为肾气发源之地，茯苓泄水以伐肾邪，桂枝行阳以散逆气，甘草、大枣甘温助脾土以制肾水。煎用甘澜水者，扬之无力，全无水性，取其不助肾邪也。”

结语

本篇论述了奔豚病的症状，病机与治疗。奔豚病因肝郁化热上冲，宜用奔豚汤类，疏肝清热，降逆平冲；因阳虚阴寒上逆，治以桂枝加桂汤，温阳降逆，散寒消阴；因阳虚水饮内动，则用苓桂甘枣汤，温阳利水，下气止悸。

胸痹心痛短气病脉证治第九

概说

本篇是论述胸痹、心痛的辨证论治，因短气是胸痹、心痛的并发症，故一并论及。篇中共有条文九条，载方十首，其中包括附方一首。本篇第一、二条阐述胸痹、心痛的发病机理，以及虚实两证的鉴别，故为胸痹、心痛的总论。第三条至第七条阐述了胸痹的主证与代表方剂，还讨论了胸痹的兼证。第八、九条则叙述了心痛的证治。胸痹与心痛在病位上有偏上、偏下之分，然病变的部位皆在心胸，又可同时发病。至于短气一证，在两证之中，有其内在联系，故合成一篇讨论。

胸痹既是证候名，又是病位和病机的概括。由于阳气微弱，阴寒内盛，引起胸中阳气闭塞不通，出现胸痛掣背为主的症状特点，故称之为胸痹。

心痛是指胃脘疼痛证，其病机是因阳虚阴盛，气机不通所致。

短气是指呼吸迫促似喘的症状，其病因多属痰饮湿浊阻碍气机的实证；而少气则多为气不足息，是心肺气虚之证。本篇所论的短气多为胸痹、心痛的伴发证。

1.师曰：夫脉当取太过不及，阳微阴弦，即胸痹而痛，所以然者，责其极虚也。今阳虚知在上焦，所以胸痹心痛者，以其阴弦故也。

【词解】

太过不及：系指关前阳微为不及，关后阴弦为太过。

【诠解】

本条论述胸痹心痛之病皆由虚处容邪，可从其脉象而溯其病源。由于胸中阳气不振，卫气不行，故关前之寸脉微；微为阳微，谓阳气之不及。若寸脉与尺脉相比，而关后之阴脉则见弦，弦为阴弦，谓阴气之太过。于是，阴邪乘于阳位，即胸痹而心痛。

“所以然者”以下，是作者自注句，说明此证责其上焦阳气极虚，虚则无以为胜邪之本，然究其所以胸痹心痛者，以其阴中之弦，乃阴中之寒邪乘上焦之虚而为痹痛，是虚为致病之因，而弦则是邪客之象也。

【选注】

《医宗金鉴》：“脉之太过则病，不及亦病，故脉当取太过不及而候病也。阳微，寸口脉微也，阳得阴脉为阳不及，上焦阳虚也；阴弦，尺中脉弦也，阴得阴脉为阴太过，下焦阴实也。凡阴实之邪，皆得以上乘阳虚之胸，所以病胸痹心痛，胸痹之病轻者即今之胸满，重者即今之胸痛也。”

2.平人，无寒热，短气不足以息者，实也。

【词解】

平人：正常无病之人。暗示非上条而胸阳虚之比。

无寒热：指无表证。

【论解】

本条继上条而言，亦有不从虚得病，而指出实邪之证，与上条对比发明。“平人”，没有感受外邪，亦无寒热，突然气急短促，呼吸不利的，一般属于实证。本证多因痰饮湿浊，阻滞胸中，升降气机不利，故胸膈痞塞短气，不足以息。此与上条胸痹，本虚标实的短气证不同。

【选注】

《金匱要略心典》：“平人，素无疾之人也。无寒热，无新邪也。而乃短气不足以息，当是里气暴实，或痰、或食、或饮，碍其升降之气而然。盖短气有从素虚宿疾而来者，有从新邪暴遏而得者。二端并否，其为里实无疑，此审因察病之法也。”

3.胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝楼薤白白酒汤主之。

栝楼薤白白酒汤方

栝楼实一枚，捣 薤白半斤 白酒七升
上三味，同煮取二升，分温再服。

【词解】

白酒：一名清酒，又称米酒。

【诠解】

本条论述胸痹的证治。胸背居于上，今胸阳不振，阴寒困郁于里，则阴来搏阳，而有喘息咳唾；呼吸之间不相续则短气；胸阳不振，寒邪塞其前后阴阳之位，则胸背疼痛。更审其脉，则寸口之阳脉沉而迟，即上所言阳微之意，关上之阴脉小紧数，即上所言阴弦之意，由尺上溢于关，为阴乘阳位。

治以栝楼薤白白酒汤，通阳散寒，豁痰下气。方中栝楼开散胸中痰结，通行经络血脉之滞；薤白辛温通阳，散结化痰，行气止痛；白酒轻扬温通，消阴散寒，载药上行。以上诸药合用，使胸中阳气宣畅，寒浊消散，胸痹则愈。

【选注】

《医宗金鉴》：“寸口脉沉而迟，沉则为里气滞，迟则为脏内寒，主上焦脏寒气滞也。关上小紧而疾，小为阳虚，紧疾寒痛，是主中焦气急寒痛也。胸背者，心肺之宫城也，阳气一虚，诸寒阴邪，得之乘之，则胸背之气，痹而不通，轻者病满，重者病痛，理之必然也，喘息、咳唾、短气证之必有也。主之以栝楼薤白白酒汤者，以辛以开胸痹，用温以行阳气也。”

【病案举例】

周某，男，25岁，社员。于1974年8月21日，因发冷，发烧，右胸剧痛，咳嗽，来门诊。检查：体温38.5℃，脉搏101次/分，血压120/84毫米汞柱，右胸部突起，第二肋以下呼吸音、语音均消失，心脏气管纵隔左移。右胸试穿，抽出50毫升浅黄色液体，送检呈瑞氏反应阳性。诊断为渗出性胸膜炎。治用栝楼薤白白酒汤：栝楼实50克，薤白20克，水煎后加白酒（60度）一小杯，早晚各服一次，连服10剂痊愈。一个月后复查未见异常。

（摘自《吉林中医药》1981,2:47）

4.胸痹，不得卧，心痛彻背者，栝楼薤白半夏汤主之。

栝楼薤白半夏汤方

栝楼实一枚，捣 薤白三两 半夏半斤 白酒一斗

上四味，同煮取四升，温服一升，日三服。

【词解】

不得卧：有不得平卧和不能卧寐两种意义。

心痛彻背：即心胸疼痛，通到后背。

【诠解】

本条论述痰浊闭塞胸痹的证治。胸痹是以喘息咳唾，胸背痛，短气为主证。由于胸阳不振，寒饮停滞，肺中气机不畅，则喘息咳唾，而致不得平卧。寒浊阻碍气机，故心痛彻背。

治以栝楼薤白半夏汤，通阳散结，逐饮降逆。方中以栝楼薤白白酒汤通阳气，散痰结，而除胸痹；加半夏逐饮降逆，亦可通阴阳，使人安卧而眠。

【选注】

《医宗金鉴》：“上条胸痹胸背痛，尚能卧，以痛微而气不逆也。此条心痛彻背不得卧，是痛甚而气上逆也，故仍用前方，又加半夏以降逆也。”

【病案举例】

李某，女性，57岁，干部。冠心病心绞痛5~6年，心前区疼痛每日2~3次，伴胸闷气短，心中痞塞，疲乏，脉弦细，苔白质淡边齿痕。此条胸痹之病，乃心阳虚，胃不和遂致气机不畅，血脉痹阻，拟通阳宣痹，心胃同治，仿栝楼薤白半夏汤合橘枳姜汤化裁。处方：栝楼30克，薤白12克，半夏15克，枳壳10克，橘皮15克，生姜6克，党参30克，生黄芪30克，桂枝12克，香附12克。

服上方2月余后，心前区痛偶见，胸闷气憋减轻，脉弦细，苔薄。心电图TV_{4~6}由倒置转低平，或双向，ST_{4~6}由下降0.1mV转回升0.05mV。

（摘自《中医杂志》1981,3:46）

5.胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之，人参汤亦主之。

枳实薤白桂枝汤方

枳实四枚 厚朴四两 薤白半斤 桂枝一两 栝楼实一枚，捣

上五味，以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升，去滓，内诸药，煮数沸，分温三服。

人参汤方

人参 甘草 干姜 白术各三两

上四味，以水八升，煮取三升，温服一升，日三服。

【词解】

抢心：突然，劫夺之意。

【诠解】

本条论述胸痹病势之剧者，即胸痹更加心中痞，客气留结不去。除胸痹证外，又见胸满、胁下之气又逆而抢夺于心，此证由胸及心而牵及胁下，为留为结为逆为抢，反映了阴邪之横行无忌，所以治用枳实薤白桂枝汤，通阳散结，降逆平冲。方中栝楼、薤白通阳散结，豁痰下气，温通血脉；枳实、厚朴泄其痞满，以降冲逆之气；桂枝通阳下气，开滞塞之寒，而降冲逆之气。诸药相配，使阳通结散，而诸证可愈。此方为挞伐邪气而设。若因正气不支，而中焦虚寒为甚，大气不转，阴寒闭塞，故见心下痞满，倦怠无力，语音低微，四肢逆冷，脉沉细等，则治用人参汤，补中温阳，以治寒湿之邪。方中人参、白术、甘草甘温补气健脾；干姜辛温，暖中焦，去寒邪，散痞除结。诸药相配，使中焦阳气开发，痞气能散，胸满则消，胸痹可愈，此即塞因塞用之法。

【选注】

《医宗金鉴》：“心中，即心下也。胸痹病，心下痞气，闷而不通者虚也。若不在心下而气结在胸，胸满连胁下，气逆撞心者实也。实者用枳实薤白桂枝汤主之，倍用枳、朴者，是以破气降逆为主也。虚者用人参汤主之（即理中汤），是以温中补气为主也。由此可知痛有补法，塞因塞用之义也。”

【病案举例】

张某，男，40岁，工人。1975年患脑血栓致轻度半身不遂，1979年在当地县医院针灸过程中，忽然出现剧烈胸痛气短，后送西安某医院救治诊断为“心肌梗死”，住院四个多月病情好转出院。出院后每日清晨天

将明时仍见心绞痛，端坐呼吸，必须含化一片硝酸甘油片。1979年10月邀余诊治，其脉沉涩无力，时有结止，形寒肢冷，每早从胃脘痛起，引至左胸胁，平日气短神怯，乃中阳不运，气虚血瘀而致，拟《金匱》人参汤加味：红丽参10克，土白术10克，川红花10克，甘草5克，干姜10克，桃仁10克，丹参10克，降香10克，元胡10克，川楝子10克，枳实10克。两剂药后，黎明时心绞痛即未出现，又以此方加减服药两个多月，近半年来很少出现心绞痛。

（摘自《陕西中医》1981,3:43）

6.胸痹，胸中气塞、短气，茯苓杏仁甘草汤主之，橘枳姜汤亦主之。

茯苓杏仁甘草汤方

茯苓三两 杏仁五十个 甘草一两

上三味，以水一斗，煮取五升，温服一升，日三服，不差更服。

橘皮枳实生姜汤方

橘皮一斤 枳实三两 生姜半斤

上三味，以水五升，煮取二升，分温再服。《肘后》、《千金》云：治胸痹，胸中怫怫如满，噎塞习习如痒，喉中涩燥唾沫。

【诠解】

本条继上条论述胸痹证亦有病势之稍缓者，其证候则为胸中时觉气之阻塞，息之出入亦觉不流利而短气。此水气滞而为病，若盛于气者则短气，治以茯苓杏仁甘草汤，使水利则气顺矣。若气盛于水者，则胸中气塞，可用橘枳生姜汤，使其气开则痹可通而病可愈。胸痹之病，有挟水挟气之异，故亦不可不知。

橘枳姜汤，温通降逆，散水行气。方中橘皮理脾肺之气机；枳实消痞下气；生姜辛温散水，降逆和胃。诸药相合，使脾胃升降得宜，痹散气行，气塞可通，痞满、气短可消。

茯苓杏仁甘草汤，有宣肺化饮之功。方中茯苓渗湿利水，疏通肺

气；杏仁利肺气，以祛痰湿；甘草和中扶正。三药相合，使水饮去，而肺气利，诸证可除。

橘枳姜汤证，病变在胃，偏于食滞气郁；茯苓杏仁甘草汤证，病变在肺，偏于水饮气塞。

【选注】

《医宗金鉴》：“胸痹胸中急痛，胸痛之重者也；胸中气塞，胸痹之轻者也。胸为气海，一有其隙，若阳邪干之则化火，火性气开不病痹也。若阴邪干之则化水，水性气阖，故令胸中气塞短气，不足以息，而为胸痹也。水盛气者，则息促，主以茯苓杏仁甘草汤，以利其水，水利则气顺矣。气盛水者，则痞塞，主以橘皮枳实生姜汤，以开其气，气开则痹通矣。”

7.胸痹缓急者，薏苡附子散主之。

薏苡附子散方

薏苡仁十五两 大附子十枚，炮

上二味，杵为散，服方寸匕，日三服。

【词解】

缓急：指治法，而要缓解胸痹急剧疼痛。

【诠解】

本条论述胸痹急痛证的治法。由于阳气衰微，阴寒痰湿壅盛，阳气不伸，胸阳痹塞，故胸中痛剧；阳气不达四肢，故见四肢厥冷。

治以薏苡附子散，温阳化湿，开痹以缓急痛。方中薏苡通络利湿，开结缓急；炮附子温阳通络，以散阴寒。二药相须，温阳开痹，阳气伸则痛缓。因为病情急迫，故用散剂，取其药力迅速而收效极快，此方有缓解血脉拘急和扶阳抑阴之效。

【选注】

《金匱玉函經二注》：“胸痹緩急者，痹之急証也。寒飲上聚心膈，使陽氣不達，危急為何如乎？故取薏苡逐水為君，附子辛熱為佐，驅除寒結，席卷而下，又烏不勝任而愉快耶。”

8.心中痞，诸逆心悬痛，桂枝生姜枳实汤主之。

桂枝生姜枳实汤方

桂枝 生姜各三两 枳实五枚

上三味，以水六升，煮取三升，分温三服。

【词解】

心中：指胃脘部。

诸逆：是指胃中水饮寒邪向上冲逆。

心悬痛：如空中悬物，动摇而痛。又心痛于上而不下，故叫悬痛。

【诠解】

本条论述寒饮气逆的心痛证治。因阳气不足，寒邪留于胃，痞塞郁滞，气机不畅，故心下痞；阴寒之邪向上冲逆，则心痛如悬而不下。

治以桂枝生姜枳实汤，温阳散寒，化饮降逆。方中桂枝、生姜通阳散寒，温化水饮，以平冲逆；枳实开结下气，可降冲逆。三药相使，共奏温通阳气、化饮散痞、降逆止痛之功。

本条与第五条皆见心中痞，气上逆证。第五条是胸痹见心中痞，气上逆。因此，在治疗上用栝楼、薤白开其胸痹，用桂枝、枳实、厚朴通阳、散痞、下气。本条是单纯的寒饮心中痞和心悬痛，故不用栝楼、薤白，而用桂枝、枳实、生姜温阳化饮，降冲下气。

本条与第六条橘枳姜汤仅一味药不同，第六条橘皮、生姜、枳实专于理气；本条以桂枝加强温阳降逆之力。可见，前者是胸中气塞较甚，本条则以寒饮上逆之心痛为主。

【选注】

《金匱要略心典》：“诸逆，该痰饮、客气而言。心悬痛，谓如悬物动摇而痛，逆气使然也。桂枝、枳实、生姜，辛以散逆，苦以泄痞，温以祛寒也。”

9.心痛彻背，背痛彻心，乌头赤石脂丸主之。

赤石脂丸方

蜀椒一两 一法二分 乌头一分，炮 附子半两，炮 一法一分 干姜一两

一法一分 赤石脂一两 一法二分

上五味，末之，蜜丸如梧子大，先食服一丸，日三服，不知，稍加服。

【诠解】

本条论述阴寒痼结心痛的证治。由于阳气衰微，阴寒痼结，经脉凝滞不通，故心痛彻背，背痛彻心，痛无休止，而四肢厥冷，脉来沉紧。

治以乌头赤石脂丸，温阳化阴，开结止痛。方中乌头、附子、干姜、蜀椒大辛大热，温阳散寒，开结行痹，通经脉而止疼痛；赤石脂收敛心阳，安定心气。

【选注】

《医宗金鉴》：“李彰曰：心痛在内而彻背，则内而达于外矣；背痛在外而彻心，则外而入内矣。故既有附子之温，而复用乌头之迅，佐干姜行阳，大散其寒，佐蜀椒下气，大开其郁，恐过于大散大开，故复佐赤石脂入心，以固涩而收阳气也。”

【病案举例】

项某，女，47岁。胃脘疼痛，每遇寒或冷而发，发则疼痛牵及背部，绵绵不已，甚或吐酸泛漾，大便溏泄，曾温灸中脘而得缓解，脉迟苔白，以丸剂缓进：

制川乌9克，川椒9克，制附子9克，干姜12克，赤石脂30克，炒白术15克，党参15克，炙甘草9克，高良姜9克，瓦楞子30克。

上药各研细末，和匀再研极细，存贮。每日服二次，每次2克，温开水冲服。

按语：本例脘痛彻背，绵绵不已，与《金匱》“心痛彻背，背痛彻心”证相似，但其病因病机，是由于脾胃阳虚，寒凝气滞所致，故方用《金匱》乌头赤石脂丸加高良姜温中散寒止痛，复人参、术、甘草以和中缓急，健脾止泻，赤石脂亦有治泻实肠的作用；煅瓦楞子止酸有显效。丸方组成，妙于化裁。经随访，服药后胃痛明显减轻、少发，大便亦成形，后再继服一料而愈。

（摘自《浙江中医学院学报》1980,4:21）

九痛丸

治九种心痛。

附子三两，炮 生狼牙一两，炙香 巴豆一两，去皮心，熬研如脂 人参 干姜 吴茱萸各一两

上六味，末之，炼蜜丸如梧子大，酒下，强人初服三丸，日三服；弱者二丸。兼治卒中恶，腹胀痛，口不能言。又治连年积冷，流注心胸痛，并冷冲上气，落马坠车血疾等，皆主之。忌口如常法。

【词解】

熬：作炒字解。

【论解】

本条是论九种心痛的治法。九种心痛，即虫心痛、注心痛、风心痛、悸心痛、食心痛、饮心痛、冷心痛、热心痛、去来心痛。由于积聚、痰饮、结血、虫注、寒冷、中恶、跌打损伤等原因，而使阳气不足，瘀血饮浊久留，痼结于胸，痹塞不通，则心胸疼痛。

治以九痛丸，温阳散寒，开结解疼。方中附子、干姜、吴茱萸温阳散寒，消散胸中痼结；狼毒燥湿杀虫，祛除痰饮；巴豆驱逐积聚，峻泻痰血凝结；人参补中益气。诸药相配，使冷结消散，阳气得伸，而瘀结去，则心胸诸证自除。

九痛丸是温热之剂，能温散阴寒邪气，故可兼治卒中阴寒恶邪引起的腹胀痛，口不能言等；或兼治阴寒浊气，痼结于内，浊气上逆引起的心胸疼痛，冷冲上气者。本方又可温散瘀血，缓解疼痛，故可治落马坠车之瘀血作痛等。

【选注】

《金匱要略直解》：“九痛者，虽分九种，不外积聚、痰饮、结血、虫注、寒冷而成。附子、巴豆散寒冷而破坚积；狼牙、茱萸杀虫注而除痰饮；干姜、人参理中气而和胃。相将治九种之心痛，巴豆除邪杀鬼，故治中恶腹胀痛，口不能言。连年积冷流注，心胸痛，冷气上冲，皆宜于辛热，辛热能行血破血，落马坠车血凝血积者，故并宜之。”

结语

本篇所论胸痹心痛的病因，是由阳微阴盛，阳气痹塞引起的胸痹心痛。因此，在治疗上，均以温通阳气，驱散寒邪为基本原则，可用栝楼

薤白白酒汤，通阳散结，豁痰下气；若痰饮较重，兼有不得卧寐，心痛彻背证者，则用栝楼薤白半夏汤，通阳散结，蠲饮降逆；兼见心下痞气，胸满，胁下逆抢心等气结实证者，用枳实薤白桂枝汤，通阳散结，降逆平冲；中焦阳虚而寒湿不化者，用人参汤，补中温阳，运化水湿；如兼有寒浊郁滞，气塞，短气，病在脾者，用橘枳姜汤，温通理脾，散水行气；病在肺而短气者，用茯苓杏仁甘草汤，宣肺化饮；如胸痛急剧者，则用薏苡附子散，温阳化湿，开痹缓痛。心痛兼寒饮在胃，心中痞，诸逆心悬痛者，用桂枝生姜枳实汤，温阳散寒，化饮降逆；若阴寒痼结，心痛彻背，背痛彻心者，用乌头赤石脂丸，温阳化阴，固阳充正，则使邪不得居；多种寒结心痛，则可用九痛丸，温阳散寒，开结解痛。

腹满寒疝宿食病脉证治第十

概说

本篇是论述腹满、寒疝、宿食三种病证的辨证论治。篇中的条文共有二十六条，载方十三首，包括附方二首。在本篇的条文中，从第一条至第八条，是阐述腹满的病理机制、脉证、虚实的鉴别、误治的变证，以及治疗原则等，可视为腹满的总论。第九条至第十六条，则是腹满的辨证论治的具体分析。第十七条至二十条，是论寒疝的方证，以及寒疝可下的脉证。第二十一条至二十六条，是论宿食的脉证和方药。由于腹满、寒疝、宿食三种病证均有腹部胀满或疼痛的证候，所以合为一篇论述。

腹满是腹中胀满，可出现在许多不同的疾病之中，所以，其病机比较复杂。本篇的腹满可概括为两大类：一为热证、实证，其病变多在于胃；一为寒证、虚证，其病变多在于脾。

寒疝，是阴寒腹痛的病变。王冰注《素问·大奇论》中曰：“疝者，寒气结聚之所为也。”所以，前人认为，凡风寒之气攻冲作痛的，或寒积高起如山的，均称之为疝，与后人所说的疝气内容有所不同。

宿食是指胃肠中有凝结的食物，停滞不消，经宿不化的一种病变，古人叫“宿食”，现多称为食积。

1. 趺阳脉微弦，法当腹满，不满者必便难，两胠疼痛，此虚寒从下上也，当以温药服之。

【词解】

便难：指大便秘结难出。

胠：音区，指胁上腋下的部位。

【论解】

本条是论述虚寒性腹满和寒疝的病因、脉证和治疗原则。趺阳脉以候胃病，若“脉微而弦”，微则中阳不足，弦属阴盛有寒。以阴加阳，脾

胃受之，则为腹满。腹满者，寒凝而气结也。假若不见腹满，而阴寒之邪旁攻胁肋，寒凝津不下达，则可出现大便难和两胁疼痛的症状。这种寒邪为病是因阳虚而寒从下上攻所致，和中焦之寒不同，故当服之温药以去其寒。

【选注】

《金匱要略心典》：“趺阳，胃脉也，微弦，阴象也。以阴加阳，脾胃受之，则为腹满。设不满，则阴邪必旁攻胁肋而下闭谷道，为便难，为两胁疼痛。然其寒不从外而从上下，则病自内生……故不当散而当温。”

2.病者腹满，按之不痛为虚，痛者为实，可下之。舌黄未下者，下之黄自去。

【诠解】

本条是辨证腹满一证有虚实之分，应通过腹诊和舌诊来辨别是虚证或是实证。虚寒腹满，是因脾经虚寒，气虚不运，寒湿内生所致。因无宿食、燥屎等有形之邪，所以腹虽满而按之不痛。实邪的腹满，因胃肠有宿食、燥屎积滞不去，使腑气阻塞不通，故腹满按之而疼痛。若胃肠积滞化热，浊热得以熏蒸，则舌苔必然黄厚，反之，若虚寒性腹满，则舌苔必不发黄为辨。治疗之法，有黄苔之腹满，当用泻下实热之法。

【选注】

《金匱要略心典》：“腹满按之不痛者，无形之气散而不收，其满为虚；按之而痛者，有形之邪，结而不行，其满为实。实者可下，虚者不可下也。舌黄者热之证，下之实去，则黄亦去。”

3.腹满时减，复如故，此为寒，当与温药。

【诠解】

本条是论述虚寒腹满的症状和治疗原则。由于脾胃虚寒，运化功能失调，虚寒之气相搏而胀满。若腹中得温，寒气消散，胀满即可减轻。若虚寒之邪又聚，而腹满如故。如此反复发作，故曰“腹满时减，复如故”。由于虚寒引起的胀满，可用温中理脾之法，温煦中阳，散其阴寒，则腹满自除。

【选注】

《金匱要略心典》：“腹满不减者，实也，时减复如故者，腹中寒气得阳而暂开，得阴而复合也。此亦寒从内生，故曰当与温药。”

4.病者痿黄，躁而不渴，胸中寒实而利不止者，死。

【诠解】

本条是论述腹满的危重之证。由于脾胃阳虚，运化功能减弱，气血资源不足，肌肤不得荣润，故面色痿黄。此证是寒非热，故口不渴；中阳虚衰，不得温运水湿，水湿阴邪壅结于胸，阴盛阳微，阴不得阳，故其人躁动不安。有躁无烦是谓阴躁，若再见下利不止，则为阳气衰败，中气不固之象。正虚邪实，顾此失彼，则难于治疗，故曰死。

【选注】

《金匱要略心典》：“痿黄，脾虚而色败也。气不至故躁；中无阳故不渴。气竭阳衰，中气已败，而后寒结于上，脏脱于下，何恃而可以通之止之乎？故死。”

5.寸口脉弦者，即胁下拘急而痛，其人嗇嗇恶寒也。

【诠解】

本条针对趺阳脉微弦，提出寸口脉弦的不同病变。两者虽然皆主寒，但趺阳主胃病，从内而生，从下而上；寸口则主病从外至，而主荣卫不和，故同属阴邪而有内外之别。在内者则大便难，在外者则嗇嗇恶寒，治以散寒之法。

【选注】

《金匱要略浅注》：“微弦脉见于趺阳与寸口者不同，以趺阳主胃，病从内生，寸口主荣卫，病从外至也。若寸口脉弦者，弦为寒而主痛，其人即胁下拘急而痛，与两胁疼痛不同，盖彼主乎内，而此主乎外也。主乎内者，其人痛而兼便难，主乎外者，其人痛而兼嗇嗇恶寒也。”

6.夫中寒家喜欠，其人清涕出，发热色和者，善嚏。

【词解】

中寒家：“中”读平声，即素体虚寒的人。

欠：即打呵欠。

【诠解】

本条是论述喜欠、善嚏的病证鉴别。欠的发生，多为素体虚寒而阳气不足之人，寒气内盛，阳气被抑，阳欲上而阴引之，是以作“欠”。嚏的发生是外感风寒，阴欲入阳拒之则嚏，而兼有鼻流清涕。嚏则阳气振奋，能外出驱寒，故发热而色和。所以说，喜呵欠者，内有阴寒，阴引阳入所致；善嚏者，为外中寒邪，阳气外出所致。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“中寒家，内阴外阳，阴引阳入则善欠。观于欠则人寐，可知其阳入阴也。若其人清涕出，发热色和者，此为外寒束闭，外阴内阳，阴阖阳开，则阳气外发而善嚏。观于嚏则其人醒，可知其人阳出阴也。一欠一嚏，阴阳各别。观下节云，外寒清涕出，便知中寒者清涕不出，观下节发热色和，便知中寒者不发热，色必清白而不和矣。此中寒外寒之分也。”

7.中寒，其人下利，以里虚也，欲嚏不能，此人肚中寒。一云痛。

【论解】

本条是论述里虚中寒的病证。本证因中阳素虚，卫外无能，复感外寒，直侵中焦，阴寒凝聚脾胃，阳虚不得驱寒外出，故欲嚏不能；中阳不运，因而下利。所以说，这是中阳虚弱，腹中寒不能拒邪外出的里虚证。

【选注】

《金匱要略心典》：“中寒而下利者，里气素虚，无为捍蔽，邪得直侵中脏也。欲嚏不能者，正为邪逼，即不能却，又不甘受，于是阳欲动而复止，邪欲去而仍留也。”

8.夫瘦人绕脐痛，必有风冷，谷气不行，而反下之，其气必冲，不冲者，心下则痞。

【词解】

谷气不行：指谷食不能消化，寓有大便不通畅的证候在内。

【论解】

本条是论述里虚寒证及误下后的变证。本证是中焦虚寒，生化竭乏，气血来源不足，日久则形体瘦弱。又感风寒邪气，伤于脾胃，脾胃运化被阻，寒凝气结，故大便不通而绕脐疼痛。若误认此证为燥实不大便，妄用苦寒之品攻之，此时谷气虽行，大便得通，但风冷之邪未除而阳气更伤。若兼伤下焦阳气，不能制伏阴寒，则其气必冲；若伤中焦阳气，使阴寒之气不化，痞于心下，而成心下痞，成心下痞则气不上冲。

【选注】

《金匱要略心典》：“瘦人脏虚气弱，风冷易入，入则谷气留滞不行，绕脐疼痛，有似里实，而实为虚冷，是宜温药以助脾之行者也。乃反下之，谷出而风冷不与俱出，正乃益虚，邪乃无制，势必犯上无等，否亦窃剧中原也。”

9.病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故，厚朴七物汤主之。

厚朴七物汤方

厚朴半斤 甘草 大黄各三两 大枣十枚 枳实五枚 桂枝二两 生姜五两

上七味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。呕者加半夏五合，下利去大黄，寒多者加生姜至半斤。

【诠解】

本条是论述腹满兼表证的治法。由于外感风寒化热，十余日不解，邪热在表，所以脉浮而数。热伤津液，肠中实热内结，故见腹满，大便虽硬未至于燥屎程度，则饮食如故。

本证是腹满兼见表热，里证重于表证，治宜厚朴七物汤，泄满散热，表里同解。本方即小承气汤合桂枝汤去芍药而成。以小承气汤峻泻肠中实热积滞，则腹满可去；以桂枝汤调和营卫，解散表热。因腹满不痛，故去芍药。此方泄满除热，为七里三表之治。

本证若见呕者，胃中亦有实热，胃逆于上，可加半夏降逆止呕；若下利者，可去大黄，以免重伤肠胃之气；如寒盛者，则增生姜之剂量以散风寒表邪。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“此有里复有表证也。腹满而能饮食，亦热邪杀谷之义；发热脉浮数，此表邪正炽之时，故以小承气治其里，桂枝去芍药以解其表，内外两解，涣然冰释，即大柴胡汤之意也。以表见太阳，故用桂枝耳。”

【病案举例】

侯某，女，30岁，湖南人。患经漏二月余，曾经中西医治疗，而经漏如故，且脐腹绞痛难忍，用吗啡止痛，收效不大，反而出现口干，舌燥，自汗，发热等症。症见脉弦细，舌苔白腻少津。结合上述诸症，显系血枯化燥，血室瘀热所致。势非攻下，莫可救治。但患者体质虚损，用下恐再伤正气，经漏更甚，以致危殆。宜本“体功重于病邪”之原则，治法当分两步。先从健脾养肝，恢复机体功能，待体质好转，方再议下，处方用逍遥散加胡黄连，数剂后，果现脉数，舌转黄燥，发热，自汗，腹痛拒按，大便秘结，数日未解。此瘀热伤津，而肠燥之征象已

备，体功已趋好转，下清之条件已具，乃用仲景厚朴七物汤。

处方：川厚朴9克，枳实9克，大黄9克，桂枝9克，甘草9克，生姜3片，大枣3个。

嘱服上方一剂，次日来诊，大为好转，自诉大便已通，下黑粪两次，每次半痰盂之多，且汗止舌润，脉静身凉，两月多来之经漏亦随之而止。继以归芍六君汤调理而愈。

（摘自《云南中医学院学报》1980,2:36）

10.腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满，呕吐，附子粳米汤主之。

附子粳米汤方

附子一枚，炮 半夏半升 甘草一两 大枣十枚 粳米半升

上五味，以水八升，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

【诠解】

本条是论述中阳虚衰，寒气久盛的腹痛证治。本病是由阳气虚衰，寒邪内盛，则腹中雷鸣。阴寒收引拘急，所以腹中切痛。寒气向上冲逆，故见胸胁逆满、呕吐。脉象可见弦紧，舌苔每见白滑。

本证治宜附子粳米汤，温阳以散寒气，降逆且止疼痛。方中附子温暖阳气，驱散寒湿；粳米、甘草、大枣缓中止痛，补虚助正；半夏辛开降逆止呕，粳米滋液安胃。诸药相伍，以使阳气振奋，浊阴之邪下降，中州之气健运，则其痛可止。

【选注】

《医宗金鉴》：“腹中切痛寒也，腹中雷鸣气也。腹中寒气，故雷鸣切痛。而胸胁逆满者，肠胃之外寒气为之也；腹痛雷鸣呕吐者，肠胃之中寒气为之也。主之以附子粳米汤，胜寒气，和内外，此治腹中寒之法也。”

11.痛而闭者，厚朴三物汤主之。

厚朴三物汤方

厚朴八两 大黄四两 枳实五枚

上三味，以水一斗二升，先煮二味，取五升，内大黄煮取三升，温服一升，以利为度。

【词解】

闭：指大便不通。

【论解】

本条是论述腹满疼痛而大便秘结的证治。由于胃肠实热积滞，闭阻不通，气滞不行，所以腹满疼痛而大便秘结。

治宜厚朴三物汤，行气通便。厚朴三物汤与小承气汤药味相同，惟小承气汤意在荡积攻实，故以大黄为君；厚朴三物汤意在行气泄满，则以厚朴为主。方中厚朴行气消满；大黄、枳实泄热导滞。三药相等，使实热积滞消除，腑气得以通畅，则诸证自解。

【选注】

《金匱要略心典》：“痛而闭，六腑之气不行矣。厚朴三物汤与小承气同，但承气意在荡实，故君大黄，三物意在行气，故君厚朴。”

12.按之心下满痛者，此为实也，当下之，宜大柴胡汤。

大柴胡汤方

柴胡半斤 黄芩三两 芍药三两 半夏半升，洗 枳实四枚，炙 大黄二两 大枣十二枚 生姜五两

上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎温服一升，日三服。

【论解】

本条是论述满痛在于心下，病属少阳、阳明的证治。本病因少阳气郁，阳明热结，胆胃积滞，壅塞不通，故按之心下满痛。“此为实也”是自注句。意在言外，而大便秘结不通，抑或下利黏秽，里急后重等证自在言外，故当以大柴胡汤下之。

方中柴胡、黄芩疏肝理气兼清胆热；芍药平胆止疼；大黄、枳实泄胃中实热积滞；半夏和胃消痞满；大枣、生姜调和脾胃。诸药相合，以解少阳阳明两经之实邪。

厚朴三物汤证与大柴胡汤证不同。本证痛在心下，病属少阳兼阳明，故治宜和解少阳，泄阳明热积为主。厚朴三物汤证，痛闭在腹，病在肠中实热积滞，故治以行气泄满为主。

【选注】

《金匱要略论注》：“此亦两解之方，但此为太阳已传少阳者言也。谓按之心下痛，此有形为病，故曰实而当下。用大柴胡者，不离乎小柴胡之和解而稍削其有形之邪耳。”

【病案举例】

邱某，男，30岁。近两周来右肋下持续剧烈胀痛，痛连右侧肩背，口苦纳钝，大便干结，失眠。脉弦滑，舌质红，苔黄糙。经X线造影摄片诊断为：胆囊炎，胆石症。此乃少阳、阳明合病，热郁胆胃，腑气不畅。拟以大柴胡汤加减：柴胡、广郁金、黄芩、生白芍、生大黄各9克，玄明粉（冲）、天花粉各6克，金钱草30克。

3剂后大便通顺，日解软粪2次，胃纳转佳，右肋胀痛减轻，夜寐易醒，舌红苔薄黄，脉弦滑。仍拟清解之剂治之：

柴胡、黄芩、生白芍、广郁金、焦山栀各9克，天花粉6克，金钱草30克，蒲公英、竹茹各15克。5剂后病瘥。改以轻剂善后，用玉米须30克、蒲公英15克代茶饮。

（摘自《广西中医药》1981,3:3）

13.腹满不减，减不足言，当须下之，宜大承气汤。

大承气汤方见前瘕病中

【诠解】

本条是论述腹满里实重证的证治。本病因肠中燥屎与气滞内结，实积化热，闭塞不通，所以腹满不得减轻。即使腹满减轻，亦是微乎其微，故谓“减不足言”。重申腹满不减为里实重证，与腹满时减的虚寒证完全不同。

本证急当下之，治以大承气汤峻下通便，行气泄满。方中大黄苦寒泄热，荡涤肠胃实热积滞；以芒硝咸寒软坚润燥，泄热通便；枳实苦微寒，下降破气，散结消痞；厚朴苦温，行气除满。四味同用，共奏峻下热结之功。

【选注】

《金匱要略心典》：“減不足言，謂虽減而不足云減，所以形其滿之至也，故宜大下。以上三方，虽緩急不同，而攻泄則一，所謂中滿者，瀉之于內也。”

14.心胸中大寒痛，嘔不能飲食，腹中寒，上冲皮起，出見有头足，上下痛而不可触近，大建中汤主之。

大建中汤方

蜀椒二合，去汗 干姜四两 人参二两

上三味，以水四升，煮取二升，去滓，内胶饴一升，微火煎取一升半，分温再服，如一炊顷，可饮粥二升，后更服，当一日食糜，温复之。

【诠解】

本条论述虚寒腹痛的证治。本病因脾胃阳衰，中焦寒盛，阴寒上阻心胸，则心胸中大寒痛；阴寒之气冲逆于胃，则呕不能食；寒气攻冲于腹，所以腹皮高起，出现似有头足的包块；经脉寒凝拘挛，故上下疼痛而不可触近。

由于本病是中焦阳虚阴盛，阴寒凝结经络，血脉拘挛作痛的虚寒腹痛证，故又可见手足逆冷，脉沉伏等证。治用大建中汤温中散寒，缓急止痛。方中蜀椒、干姜温中散寒，干姜与蜀椒同用，温阳散寒力强而猛，使中焦阳气恢复，寒气消散，则疼痛可除；人参、饴糖温补脾胃，荣养血脉，缓解拘急疼痛。诸药相合，以使中气建立，阳气温和，阴寒消散，血脉不滞，则诸证自愈。

服后一炊顷，令其饮粥者，亦是温养中焦之气，以助药力而去寒邪之意。

【选注】

《医宗金鉴》：“心胸中大寒痛，谓腹中上连心胸大痛也，而名大寒痛者，以有厥逆脉伏等大寒证之意也。呕逆不能饮食者，是寒甚格拒于中也。上冲皮起，出现有头足者，是寒甚格坚于外。上下痛不可触近，是内而藏府，外而经络，痛之甚亦由寒之甚也。主以大建中汤，蜀椒、干姜大散寒邪，人参、饴糖大建中虚。服后温复，令有微汗，则寒

去而痛止，此治心胸中寒之法也。”

【病案举例】

陈某，女，37岁。素体虚寒，常喜热饮，一日食后不慎受凉，脘腹急痛如刀割，痛觉放射至肩胛部，痛楚甚剧，时而前俯后仰，或弯腰按腹；时而辗转反侧，又合眼甩头。伴有恶心，呕吐苦汁，并吐出蛔虫一条。触诊：右上腹近心窝处剧痛拒按，四肢发冷。察其舌淡，苔薄白，脉象沉弦。诊断为蛔厥，即胆道蛔虫症，治拟温中散寒，安蛔止痛，予大建中汤：川椒3克，干姜6克，党参9克，红糖1匙。先煎前三味，去滓，纳红糖，微火调烱，趁热小口顿服。服后随即痛止，安然入寐，熟睡一夜。次日下床，一如常态，嘱其节饮食，慎生冷，善自调理，至今十七年，追访未再发。

（摘自《浙江中医杂志》1981,5:210）

15.胁下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤。

大黄附子汤方

大黄三两 附子三枚，炮 细辛二两

上三味，以水五升，煮取二升，分温三服，若强人煮取二升半，分温三服，服后如人行四五里，进一服。

【诠解】

本条论述寒邪结于胁下的证治。本病是因寒凝肝胆部位，故胁下一侧偏痛。发热，乃是阳气被郁所致。若其脉弦紧的，“此寒也”，是自注句，说明此证属寒而非热，治当以温药下之，用大黄附子汤，温阳通便而止痛。方中附子温经祛寒，细辛散寒止痛，大黄泻下通便。诸药相配，共奏祛寒开结、通便止痛之功。

【选注】

《金匱要略心典》：“胁下偏痛而脉紧弦，阴寒成聚，偏着一处，虽有发热，亦是阳气被郁所致，是以非温不能已其寒，非下不能去其结，故曰宜以温药下之。程氏曰：大黄苦寒，走而不守，得附子、细辛之热，则寒性散而走泄之性存，是也。”

【病案举例】

陈某，男，44岁，医生。患慢性结肠炎多年。因腹胀腹痛，呕吐，于1977年9月9日住院治疗。经西医灌肠、肛门排气及注射新斯的明等处理腹痛不减。X光腹部透视及钡剂灌肠，发现双下腹有三个液平面，拟诊为肠梗阻。9月14日邀中医会诊。症见：腹胀满不能平卧，痛苦呻吟，烦躁不安，尤以两侧胁下疼痛拒按为甚，大便三天未解，体温38℃，舌淡苔白，脉弦紧。综合脉症，“属寒邪内积，腑气不通，不通则痛，”诊为寒疝腹痛。宗《金匱》大黄附子汤。

处方：附子18克，大黄10克，细辛6克，水煎服。服后十小时大便仍不通。嘱再进一剂。约三小时许，大便得通，腹痛大减，依原方再服三天，每天一剂，诸症解除。后用黄芩汤合赤小豆当归散调理而安，于9月20日痊愈出院。

（摘自《福建中医药》1981,5:29）

16.寒气厥逆，赤丸主之。

赤丸方

茯苓四两 半夏四两洗 一方用桂 乌头二两，炮 细辛一两《千金》作人参
上四味，末之，内真朱为色，炼蜜丸如麻子大，先食酒饮下三丸，日再夜一服，不知，稍增之，以知为度。

【诠解】

本条是论述阴寒痰湿之邪气上逆心胃的证治。然述证简略，以方补证，当有呕吐、厥冷、心悸等证。赤丸有温阳止痛，降逆除痰之功。方中乌头、细辛温阳散寒而止痛；茯苓、半夏温化痰湿，以治心悸；朱砂重镇安神，以护心胸正气。诸药相合，则阳复阴散，厥逆之证可解。

《雷公药性赋》认为，乌头反半夏，不能同用，此处仲景两药并用，相反相成，且用量较小，而又以蜜制其悍，故可获良效。

【选注】

《金匱悬解》：“寒气厥逆，寒气在内，手足厥冷也。四肢秉气于脾胃，寒水侮土，四肢失秉，是以厥逆。寒水上凌，心火渐败，是宜泄寒水而护心君。茯苓、半夏泄水而驱寒湿；细辛、半夏降浊而下冲气，真朱保护心君而止疼痛也。”

17.腹痛，脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒；紧则不欲食，邪正相搏，即为寒疝。寒疝绕脐痛，若发则白津出，手足厥冷，其脉沉紧

者，大乌头煎主之。

大乌头煎方

乌头大者五枚，熬去皮，不^咬咀

上以水三升，煮取一升，去滓，内蜜二升，煎令水气尽，取二升，强人服七合，弱人服五合。不差，明日更服，不可一日再服。

【词解】

白津：剧烈疼痛所出的冷汗。

【诠解】

本条论述寒疝的病机、证候和治法。本病由于寒结于内，聚而不散，犯寒即发，谓之寒疝。此证初起，腹满而脉弦紧。弦紧脉皆属阴，但弦之阴从内生，紧之阴从外得。弦则卫气不行即恶寒，阴出而痹在外之阳；紧则不欲食，阴入而痹其胃内之阳。卫阳与胃阳两衰，而内寒与外寒交盛，于是，阴反无畏而上冲，阳反不治而下伏，则谓“邪正相搏，即为寒疝，寒疝绕脐痛”。若发作之时，阴寒内动，疼痛剧烈，而使人汗出，手足厥冷；若并见沉紧之脉，则沉主里，紧主寒、主痛、主实，故急以大乌头煎散寒破结以救阳气。乌头大辛大热有毒，散沉寒痼冷而止疼痛；佐白蜜以监乌头之毒烈，且润燥养血，并能缓急止痛而延长疗效。方后注云：“强人服七合，弱人服五合”，“不可一日再服”，可知本方药力峻烈，理宜慎用。

【选注】

《金匱要略论注》：“此寒疝之总脉证也。其初亦止腹满，而脉独弦紧，弦则表中之卫气不行而恶寒，紧则寒气痹胃而不欲食，因而风冷注脐，邪正相搏而绕脐痛，是外之阳，胃中之阳，下焦之阳皆为寒所痹，因寒脐痛，故曰疝。至发而白津出，寒重故冷涎也；手足厥冷，厥逆也；其脉沉紧是寒已直入于内也，故以乌头一味，合蜜顿服之，此攻寒峻烈之剂，即后人所谓霹雳散也。”

18.寒疝，腹中痛及胁痛里急者，当归生姜羊肉汤主之。

当归生姜羊肉汤方

当归三两 生姜五两 羊肉一斤

上三味，以水八升，煮取三升，温服七合，日三服。若寒多者，加生姜一斤；痛多而呕者，加橘皮二两，白术一两。加生姜者，亦加水五升，煮取三升二合服之。

【诠解】

本条论述血虚寒疝的证治。病起于肝血虚而寒邪内凝，故腹中痛及胁痛里急，“里急”指腹、胁疼痛有拘急之象。根据临床所见往往出现两目视力降低。

治宜当归生姜羊肉汤，采用“精不足者，补之以味”的理论，故用味厚之羊肉以温补肝血，配当归以润肝血之急；重用生姜温中散寒止痛。方后注云：“寒多者，加生姜一斤”，为温散阴寒也。“痛而多呕”，乃肝气上逆犯胃所致，故加橘皮、白术理气和胃为宜。凡寒疝疼痛，必有血脉不和之变，故大乌头煎润之以白蜜，本方治之以羊肉，其药虽异，而理则不殊。

【选注】

《金匱要略心典》：“此治寒多而血虚者之法。血虚则脉不荣，寒多则脉绌急，故腹胁痛而里急也。当归、生姜温血散寒，羊肉补虚益血也。”

【病案举例】

岳某，女，52岁。常因头痛，身疼而服大量阿司匹林，已近20年。每当饮冷或遇寒即觉腹痛。1976年12月13日，突然头痛加剧，鼻齿衄血百余毫升，腹中绞痛，全身满布米粒大小之紫癜，尤以躯干为多，于次日住院治疗。诊见面色萎黄，形寒肢冷，紫斑大小不等，不隆起，压之不退色。舌淡苔白，脉沉细无力。化验：血小板34000/立方毫米。遂诊为“血小板减少性紫癜”，虚寒肌衄，宜补血温阳，方拟当归生姜羊肉汤：当归50克，生姜50克，羊肉100克，水煎服，每日一剂。

服药九剂，诸证悉除，紫斑逐渐消退，化验：血小板140000/立方毫米。于1976年12月24日病愈出院，随访三年未见复发。1979年12月化验为170000/立方毫米。

（摘自《吉林中医药》1981,1:38）

19.寒疝，腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺诸药不能治，抵当乌头桂枝汤主之。

乌头桂枝汤方

乌头

上一味，以蜜二斤，煎减半，去滓，以桂枝汤五合解之，令得一升后，初服二合，不知，即服三合，又不知，复加至五合。其知者如醉状，得吐者为中病。

桂枝汤方

桂枝三两，去皮 芍药三两 甘草二两，炙 生姜三两 大枣十二枚

上五味，剉，以水七升，微火煮取三升，去滓。

【诠解】

本条论述寒疝兼有表证的证治。寒疝由于阳虚不温，阴寒内结，则腹中疼痛；阳虚不煦，气血不温，则四肢逆冷而麻木不仁；此时，若寒客体表，则身体疼痛。此证表里皆寒而内外皆痛，故灸刺诸药不能治，只有用抵当乌头桂枝汤方能奏效。

本方即乌头煎合桂枝汤。乌头煎重于温里，温阳散寒而治腹痛；桂枝汤解表散寒，调和营卫而止身痛。表里寒邪俱解，则手足不仁，逆冷等证可愈。必须指出的是：乌头的毒性很大，宜小量试服，无反应者，方可增量。服后如醉酒状或恶心呕吐，是药已中病的反应。如果发现药后呼吸急迫，心跳加快而有歇止以及头痛等证，为中毒反应，要立刻停药，急服绿豆汤或黑豆甘草汤以解其毒。

【选注】

《金匱要略论注》：“起于寒疝腹痛而至逆冷，手足不仁，则阳气大痹，加以身疼痛，营卫俱不和，更灸刺诸药不能治，是或攻其内或攻其外，邪气牵制不服，故以乌头攻寒为主，而合桂枝全汤以和营卫。所谓七分治里，三分治表也。如醉状则营卫得温而气胜，故曰知；得吐，则阴邪不为阳所容，故上出而为中病。”

20.其脉数而紧，乃弦，状如弓弦，按之不移。脉数弦者，当下其寒；脉紧大而迟者，必心下坚；脉大而紧者，阳中有阴，可下之。

【诠解】

本条论述寒疝当下的脉候。“脉数而紧乃弦。”数者，急迫也；紧者，有力也。数紧同见，乃为弦而有力之脉，故按之挺直不移，状如弓弦。此脉主阴寒内结肠胃，阳气起而与争，阳气在外，阴寒在内，阳中有阴，故脉来数弦。宜用温下之剂，驱除阴寒，而勿须温散。

“脉紧大而迟者”，是因寒实之邪凝聚肠胃，而痼结更甚，则心下痞硬，故脉来紧迟。若阳气起而驱寒，则脉大而紧，为阳中有阴，可以用温下之法。弦紧是寒疝的主脉，脉来弦紧兼见数、大或迟，皆为寒结可下之证，如用大黄附子汤法等。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉数为阳，紧弦为阴，阴阳参见，是寒热交至也。然就寒疝言，则数反从弦，故其数为阴凝于阳之数，非阳气生热之数矣；如就风疝言，则弦反从数，故其弦为风从热发之弦，而非阴气生寒之弦者，与此适相发明也。故曰脉数弦者当下其寒。紧而迟，大而紧亦然。大虽阳脉，不得为热，正以形其阴之实也。故曰阳中有阴，可下之。”

附方

《外台》乌头汤

治寒疝腹中绞痛，贼风入攻五脏，拘急不得转侧，发作有时，使人阴缩，手足厥逆。方见上。

【诠解】

本条论述寒疝表里寒盛的治法，即前面所说的乌头桂枝汤证。本证为阴寒凝聚腹中，经脉痉挛，故腹中绞痛；风寒乘虚而入，急速内犯，入攻五脏，故拘急不得转侧；阳虚阴盛，不能温养四肢，则手足厥逆；寒主收引，故阴缩。近人门纯德用此方治寒性脉管炎而疼痛难忍者，服之效应如神。

【选注】

《金匱要略论注》：“云贼风入攻五脏，则知此为外邪内犯至急，然未是邪藏肾中，但刻欲犯肾，故肾不为其所犯则不发，稍一犯之即发，发则阴缩，寒气敛切故也。肾阳不发，诸阳皆微，故手足厥逆。”

《外台》柴胡桂枝汤方

治心腹卒中痛者。

柴胡四两 黄芩 人参 芍药 桂枝 生姜各一两半 甘草一两 半夏二合半 大枣六枚

上九味，以水六升，煮取三升，温服一升，日三服。

【诠解】

本条论述表邪挟内热腹痛的证治。本证因外感风寒，内传少阳，气血不得通畅，肝胆疏泄失利，气郁化热，故心腹疼痛。

治以小柴胡汤和解少阳，清热开郁，用桂枝汤调和营卫，解散风寒。二方相合以奏缓急止痛，和里解表之功。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“有表邪而挟内寒者，乌头桂枝汤证也；有表邪而挟内热者，柴胡桂枝汤证也。以柴胡、桂枝、生姜升阳透表；人参、半夏、甘草、大枣和中开郁；黄芩、芍药治寒中有热杂合。此表里两解，寒热兼除之法也。”

《外台》走马汤

治中恶心痛腹胀，大便不通。

巴豆二枚，去皮心熬 杏仁二枚

上二味，以绵缠槌令碎，热汤二合，捻取白汁，饮之当下，老小量之。通治飞尸鬼击病。

【词解】

走马汤：形容病情急速和药效急速，捷如奔马故名。

中恶：病名。俗称绞肠乌纱。有忽然仆倒，精神昏乱，颜面发黑，心腹痛、胀满，大便不通等证。有吐血、衄血症状的，称“鬼击”；有喘咳气息急迫症状的，称“飞尸”；见有腹脐绞痛，上冲心胸胀闷的，则称“寒疝”。

【诠解】

本方论述腹痛大便不通的证治。中恶之证，因臭秽恶毒之气，从口鼻而入于心肺，气血不行，肠胃脏腑被寒浊秽毒壅塞，所以胸胁腹内绞急切痛，欲吐不吐，欲泻不泻，为寒实内结，升降受阻之证。

治宜走马汤，速攻寒实，以开闭塞。方中巴豆为大热大毒峻猛之品，急泻毒邪之结；佐以杏仁开利肺气，又利大肠之闭。二药相配，使毒邪或从大便排出，或从口呼出，或吐泻交作，而使其病可愈。

【选注】

《金匱要略论注》：“中恶心痛，此客忤也；腹胀不大便，是正气不复能运。此时缓治，皆不暇及，故须以巴豆峻攻，杏仁兼利肺与大肠之气，一通则无不通，故亦主飞尸鬼击，总是阴邪不能留也。”

21.问曰：人病有宿食，何以别之？师曰：寸口脉浮而大，按之反涩，尺中亦微而涩，故知有宿食，大承气汤主之。

【诠解】

本条从脉象的变化论述宿食的证治。宿食多因饮食不节，食积不化，滞阻中焦而成。宿食积滞，谷气内盛，壅塞于中，胃气上逆，故寸口脉浮而大；宿食壅遏脾胃，中焦气机不畅，所以按之脉涩；食滞久郁，脾胃不能运化，糟粕停于大肠，下焦气血不得宣通，故尺中脉微而涩。

本证治应通泻胃肠，消食导滞，如大承气汤法。

【选注】

《金匱要略心典》：“寸口脉浮大者，谷气多也。谷多不能益脾而反伤脾，按之脉反涩者，脾伤而滞，血气为之不利也。尺中亦微而涩者，中气阻滞，而水谷之精气不能逮下也，是因宿食为病，则宜大承气下其宿食。”

22.脉数而滑者实也，此有宿食，下之愈，宜大承气汤。

【诠解】

本条是论述宿食初停的证治。饮食不节，谷气郁滞肠胃，郁而化热，故脉数；食阻肠道，滞而能通，营卫充实而抗邪，脉来流利如珠从指下而过，故见脉滑。脉数而滑者，为宿食初滞不久，当以大承气汤下之。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“滑与涩相反，何以俱为实宜下？滑者涩之浅，而实邪欲成未成者；涩者滑之深，而实邪已成者。故不论为滑为涩，兼大而见，则有物积聚，宜施攻治，无二理也。”

23.下利不欲食者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。

大承气汤方见前痙病中

【诠解】

本条论述宿食下利的证治。饮食太过，壅遏于胃肠，失其运化之能则下利。虽利，但胃中食滞不得出，故下利而又不欲食。治以大承气汤去其宿食，恢复脾胃升降之机则病愈。

以上三条论述宿食证治。二十一条言“大承气汤主之”是肯定之语。因积滞已久，不用攻之，则虑其正虚。二十二条是宿食初停不久，病情较轻，虽可下之，但不一定用重剂，故用大承气汤加一“宜”字，表示有斟酌余地。二十三条是宿食下利，虽下利而宿食未净，尚无虚象，宜大承气汤攻下宿食。

【选注】

《金匱要略心典》：“谷多则伤脾，而水谷不分，谷停则伤胃，而恶闻食臭，故下利不欲食者，知其有宿食当下也。夫脾胃者，所以化水谷而行津气，不可或止者也。谷止则化绝，气止则机息，化绝机息，人事不其顿乎？故必大承气速去其停谷，谷去则气行，气行则化续而生以全矣。若徒事消克，将宿食未去而生气已消，岂徒无益而哉。”

【病案举例】

唐某，女，35岁，农民。主诉：人工流产后腹胀且痛，肛门坠胀难受，坐时犹如锥刺，卧不安，寝不宁，纳呆食少，大便日行数次，量少质稀，或如水样，已历两月。当地诊断为肠炎。经用痢特灵等抗菌药物未效。病势日增，形体消瘦，四肢软弱，某医曾投以大剂补方，服几帖后腹胀气窒，饮食不进，诸症加剧，而来我院要求手术治疗。当时患者偏坐于凳子一角，言其所苦。妇科检查：外阴经产式，阴道通畅，宫颈轻度炎症，子宫体中位大小正常，但左后壁连及左侧少腹有肿块，坚硬压痛拒按，重按时肛门有少许清水流出，此乃燥屎内聚，热结旁流。拟大承气汤加味以荡涤肠腑之燥便。

处方：大黄9克（后下），芒硝9克（冲），枳实9克，厚朴6克，木

香9克，槟榔9克，桃仁9克，生甘草3克。

药后肠鸣，腹痛阵作，翌晨解出燥屎十余枚，坚如弹丸，顿感腹部舒适。原方再进1帖，排出大量坚硬大便。第三次复诊又给增液承气汤加減而收功。

（摘自《江苏中医杂志》1981,1:31）

24.宿食在上脘，当吐之，宜瓜蒂散。

瓜蒂散方

瓜蒂一分，熬黄 赤小豆一分，煮

上二味，杵为散，以香豉七合煮取汁，和散一钱匕，温服之，不吐者，少加之，以快吐为度而止。亡血及虚者，不可与之。

【诠解】

本条是论述宿食在上脘的证治。宿食积滞在于上脘，可见胸脘痞闷、胀痛，欲吐而不能出等证。

宜用瓜蒂散因势利导，使邪从上而越之。方中瓜蒂味苦，涌吐实邪；赤小豆味酸性泄，此为酸苦涌泄之治，又佐以香豉，宣开胸脘郁结，服药后快吐即停药。本方为实邪郁上脘而设，然药性悍易伤正气，所以亡血及虚人，不可与之。总之，宿食在上宜吐，在中宜消，在下宜泻，三法已立，因证而施。

【选注】

《金匱要略编注》：“此骤食停滞胃之上脘也。食壅上脘胸膈之间，脾气不得转输，当遵《内经》高而越之之法，用瓜蒂、香豉、赤小豆煎汤，涌吐，其邪立解矣。”

25.脉紧如转索无常者，有宿食也。

【诠解】

本条论述宿食的脉象。脉紧如转索无常者，是形容脉同绳索转动之状，来往有力，左右弹人之手。主宿食不化，停积于中，正邪相搏，则脉紧张有力。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉紧如转索无常者，紧兼有滑象，不似风寒

外感之紧，为紧而带弦也。故寒气所束者，紧而不移；食气所发者，乍紧乍滑，如以指转索之状，故曰无常。”

26.脉紧，头痛风寒，腹中有宿食不化也。一云：寸口脉紧。

【诠解】

本条论述宿食与外感风寒的鉴别。外感风寒和宿食都有脉紧，头痛等证。宿食头痛，是因食积不化，郁滞于中，清阳不升，浊气上乘，故见头痛，又有胸痞，恶心厌食，腹痛等证。外感风寒头痛，是由风寒外束太阳之经，又有发热，恶寒等证。食滞脉紧，如转索无常。风寒外束，脉紧而浮。一为食滞，一为外感，综合脉证，可以鉴别。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉紧头痛风寒者，非既有宿食，而又感风寒也，谓宿食不化，郁滞之气上为头痛，有如风寒之状，而实为食积类伤寒也。仲景恐人误认为外感而发其汗，故举以示人曰：‘腹中有宿食不化也。’意亦远矣。”

结语

腹满有寒热虚实的不同，故治法亦有所别。如里实气滞不通的腹满，宜行气除满，用厚朴三物汤主之；若见腹满急剧不减，宜峻下通便，行气除满，大承气汤主之；腹满若兼表证，宜解表除满，表里同治，厚朴七物汤主之；心下满兼有少阳证者，宜和解少阳，兼泻阳明热结，大柴胡汤主之；寒实结滞，胁下偏痛，在一侧的，宜温下寒结，大黄附子汤主之；若脾胃阳虚，阴寒内盛，腹中雷鸣切痛者，宜温阳散寒，降逆止痛，附子粳米汤主之；脾胃阳衰，中焦寒盛，上冲皮起见有头足，痛而不可触近者，宜温中散寒，缓急解痉，大建中汤主之；脾肾阳虚，水湿内停，以厥逆为主的，宜温阳止痛，降逆除湿，赤丸主之。

寒疝因血虚有寒，腹痛，胁痛里急的，宜温养补血，兼散寒气，当归生姜羊肉汤主之；若阴寒内结，绕脐疼痛，痛剧则自汗和手足厥冷的，宜驱寒止痛，大乌头煎主之；若表里皆寒，有腹中痛，逆冷，手足不仁和身痛等症的，宜驱散阴寒，调和营卫，乌头桂枝汤主之。

附方三首：有表里皆寒，贼风内入，即用乌头桂枝汤，温里解表，散寒止痛；表邪兼见内热郁结，宜用柴胡桂枝汤，清热开郁，解散表邪；若寒浊秽毒壅塞于里的寒结证，可用走马汤，攻逐寒实邪气。

宿食在上脘，常见恶心，泛泛欲吐的，可用瓜蒂散，因势利导，吐其宿食；宿食在下，常见腹痛等证者，可用大承气汤泻下积滞。

五脏风寒积聚病脉证并治第十一

概说

本篇论述了五脏为病的证治，用以体现五脏为核心的辨证方法。其中既有中风、中寒等邪伤脏，也有气血阴阳不和的病机。至于五脏的死脉论述，反映了人以胃气为本的思想。篇中还论述了三焦为病与积聚等病。

本篇中共有条文二十条，载方三首。其中第一条至第三条论肺中风、中寒证和真脏脉象。第四条至第七条论肝中风、中寒证、真脏脉象和肝着的证治。第八条至第十二条论心中风、中寒证、真脏脉象和癫狂证。第十三条至第十五条论脾中风、真脏脉象和脾约的证治。第十六、十七、十八、十九、二十条论肾著的证治和真脏脉象。第十八、十九、二十条则论三焦病变。第二十条是论积聚^榮气的脉证。本篇条文虽只有二十条，但内容极为丰富，可供我们学习和研究。

1.肺中风者，口燥而喘，身运而重，冒而肿胀。

【词解】

中：读仲。

身运：当身体运动讲。

冒：指头目眩冒。

【诠解】

本条是论述肺中风的辨证。由于风热伤肺，热灼津液，津枯不行，肺气壅滞，津不上承，气不下降，故口燥而喘。肺之清肃之令不行，浊阴不降，故时作昏冒。肺主一身之气，肺气不治，故身运而重。肺气不能通调水道，下输膀胱，水气外溢，故身体肿胀。

【选注】

《金匱要略心典》：“肺中风者，津结而气壅。津结则不上潮而口

燥；气壅则不下行而喘也。身运而重者，肺居上焦，治节一身，肺受风邪，大气则伤，故身欲动而弥觉其重也。冒者，清肃失降，浊气反上，为蒙冒也。肿胀者，输化无权，水聚而气停也。”

2.肺中寒，吐浊涕。

【诠解】

本条是论述肺中寒的辨证。由于寒邪伤中于肺，肺受阴寒之邪，则津液凝聚不行，故时吐痰涎浊涕。

【选注】

《金匱要略心典》：“肺中寒，吐浊涕者，五液在肺为涕，寒气闭肺窍而蓄脏热，则浊涕从口出也。”

3.肺死藏，浮之虚，按之弱如葱叶，下无根者死。

【词解】

肺死脏：指肺将死而真脏之脉见。真脏脉，即无胃气的死脉。

【诠解】

本条是论述肺脏将死的脉候。肺脏将死，肺气将绝，脏真涣散；阳浮于上，故浮取脉虚，沉取弱如葱叶，中空无根者，为肺气已败，故主死。

【选注】

《金匱要略心典》：“肺死脏者，肺将死而真脏之脉见也。浮之虚，按之弱如葱叶者，沈氏所谓有浮上之气，而下无翕之阴是也。”

《内经》云：“真肺脉至，大而虚，如以毛羽中人肤。亦浮虚中空，而下复无根之象尔。”

4.肝中风者，头目𦏧，两胁痛，行常伛，令人嗜甘。

【词解】

𦏧：动也。

行常伛：经常曲背而行。

【诠解】

本条是论述肝中风的辨证。由于风热之邪，中于肝经，而使肝血不能滋润，以致风阳上旋，故头目𦏧动。

另外，肝之经脉失养，所以两胁作痛，而行则曲背不能伸直。肝经燥急，求助于味，故喜食甘味，以缓肝血之急。

【选注】

《医宗金鉴》：“肝中风，外合于筋，肝中风邪，风胜则动，故头目^眴动也。两胁肝之部，肝受病故两胁痛也。风伤筋，故行常伛偻也。肝苦急欲甘缓之，故令人嗜甘也。”

5.肝中寒者，两臂不举，舌本燥，喜太息，胸中痛，不得转侧，食则吐而汗出也。《脉经》、《千金》云：时盗汗咳，食已吐其汁。

【词解】

舌本：舌根。

【诠解】

本条是论述肝中寒的辨证。由于阴寒之邪，客于肝经，以致筋脉收引拘急，所以两臂不能上举。肝寒凝滞，气郁而不条达，故喜太息，以及胸中痛，而身体不得转侧。

肝病传胃，胃气失于和降，则食而作吐，吐则汗出。肝寒郁结，津液不行，不能上濡，因肝脉上连舌本，所以舌本干燥。

【选注】

《金匱要略心典》：“肝中寒，两臂不举者，肝受寒而筋拘急也。徐氏曰：四肢虽属脾，然两臂如枝，木之体也，中寒则木气困，故不举。亦通。肝脉循喉咙之后，中寒者逼热于上，故舌本燥。肝喜疏泄，中寒则气被郁，故喜太息。太息，长息也。肝脉上行者挟胃贯膈，故胸痛不能转侧，食则吐而汗出也。”

6.肝死藏，浮之弱，按之如索不来，或曲如蛇行者死。

【词解】

如索不来：沉取脉象如绳索，郁阻坚劲，有伏而不起，劲而不柔之象。

曲如蛇行：脉象如蛇行，弯曲之状，虽左右奔引，而不能上行，亦伏且劲之意。

【诠解】

本条是论述肝脏将死的真脏脉候。由于肝之阴血大伤，真气将散，故脉浮取而弱，沉取按之如索不来。脉委屈不前，或曲如蛇行而无柔和

之胃气，故曰死。

【选注】

《医宗金鉴》：“肝中风寒之邪，若脉见浮之极弱，按之不弦，是失其肝之本脉也。今按之如索不来，曲如蛇行而去，夫索曲蛇行，去而不来，非皆肝之死脉乎？”

7.肝著，其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲饮热，旋覆花汤主之。臣亿等校诸本旋覆花汤，皆同。

【论解】

本条是论述肝著的辨证论治。由于气郁寒凝，胸胁脉络郁滞，则著而不行，可见胸胁痞闷，或见胀痛不休。若此时以足蹈其胸上，或以手按摩之，可使凝滞的气血暂得舒展，而减轻疼痛。此病先未苦时，但欲饮热为舒，此热能胜寒，而有利于气血之行也。

治宜旋覆花汤，下气散结，活血通络。方中旋覆花咸温，下气散结，舒肝利肺；葱白通胸中之阳气；新绛现无，可用茜草根、红花代替，有活血化瘀之功。本方能使血络畅行，阳气通利，则瘀血去，而肝著可愈。

【选注】

《金匱要略浅注》：“肝主疏泄，气血滞而不行，如物之粘著为病，名曰肝着，其人常欲以手蹈其胸上，藉按摩以通其气也。盖血气之郁滞，遇热略散，苟至大苦时，则病气发而为热，又非攻热所能胜矣，故必先于未苦时，但欲求其散而思饮热，此由病证而得其病情以为据，以旋覆花汤主之。”

8.心中风者，翕翕发热，不能起，心中饥，食即呕吐。

【词解】

翕翕：鸟羽闭合之状，用以形容发热在表的情况。一解为鸟羽开合的形状。

【论解】

本条是论述心中风的辨证。由于心经有热，复中风邪，风热相合，而向外发泄，所以翕翕发热。风热伤气，则无力起床活动。风热壅于上，热伤胃阴，故又心中饥而不能食，食入则助热而气逆即吐。

【选注】

《金匱要略心典》：“翕翕发热者，心为阳脏，风入而益其热也。

不能起者，君主病而百骸皆废也。心中饥，食则呕者，火乱于中，热格于上也。”

9.心中寒者，其人苦病心如啖蒜状，剧者心痛彻背，背痛彻心，譬如蛊注，其脉浮者，自吐乃愈。

【词解】

心如啖蒜状：心里难受，好像吃蒜后心中嘈杂而辣。

蛊注：据称古时南方有养蛊之术，人被其害，则叫“蛊注”。

【诠解】

本条是论述心中寒的辨证。由于心中于寒，寒凝脉络，阳气闭结，心火被郁，欲越而不得越，故心中有灼辣感，而如啖蒜之状。如病情进一步加剧，则胸阳为阴寒痹阻尤甚，故见心痛彻背，背痛彻心，譬如似蛊注那样的痛苦。如其人脉浮者，主阳气能伸，将拒邪外出，而自吐乃愈。

【选注】

《金匱要略直解》：“《内经》曰：心恶寒者，寒邪干心，心火被敛而不得越，则如啖蒜状而辛辣，愤愤然而无奈，故甚则心痛彻背，背痛彻心如蛊注之状也；若其脉浮者，邪在上焦，得吐则寒邪越于上，其病乃愈。”

10.心伤者，其人劳倦即头面赤而下重，心中痛而自烦发热，当脐跳，其脉弦，此为心藏伤所致也。

【诠解】

本条是论述心经气血损伤的辨证。心伤由于心经气血损伤于内，故稍有劳倦，心阳即浮于上而不能下周，故证见头面赤，而下身反沉重；血虚不养于心，热动于中，故心中痛而发烦。心阳浮动于上，则不能镇摄下焦之阴与水寒之气，水气蠢蠢欲试，故而当脐跳动，其脉则弦。弦，主阴，主水也。

【选注】

《金匱要略心典》：“心伤者，其人劳倦，即头面赤而下重。盖血虚者，其阳易浮，上盛者，下必无气也。心中痛而自烦发热者，心虚失养，而热动于中也。当脐跳者，心虚于上而肾动于下也……今脉弦，是变温润圆利之常而为长直劲强之形矣，故曰：此为心脏伤所致也。”

11.心死藏，浮之实，如丸豆，按之益躁疾者死。

【词解】

丸豆：丸当动词解，即和手指丸捻豆子。

【诠解】

本条是论述心脏将死的脉候。因为心血枯竭，心阳脉动，血脉失去温润和调之象，所以脉浮取坚硬躁急，如手丸麻豆而按之益躁急不宁的，为阴气已绝，故主死。

【选注】

《金匱要略心典》：“经云：‘真心脉至，坚而搏，如循薏苡子，累累然。’与此浮之实如麻豆，按之益躁疾者，均为上下坚紧，而往来无情也，故死。”

12.邪哭使魂魄不安者，血气少也。血气少者，属于心，心气虚者，其人则畏，合目欲眠，梦远行而精神离散，魂魄妄行。阴气衰者为癫，阳气衰者为狂。

【词解】

邪哭：人病如邪所凭而为悲哭。

【诠解】

本条是论述血气虚少的辨证。气血虚少，血不养心，魂魄不安，则其人悲泣如邪哭，并时常发生恐怖情绪。精神离散，合目欲眠，多梦远行。若气血虚少，经久不愈，以致阴气衰者可以转变为癫；阳气衰者亦可转变为狂。盖必正气先虚而后邪入为病也。

【选注】

《金匱要略心典》：“邪哭者，悲伤哭泣，如邪所凭，此其标有稠痰浊火之殊，而其本则皆心虚而血气少也。于是寤寐恐怖，精神不守，魂魄不居，为癫为狂，势有必至者矣。经云：‘邪入于阳则狂，邪入于阴则癫。’此云：‘阴气衰者为癫，阳气衰者为狂。’盖必正气虚而后邪气入，经言其为病之故，此言其致病之原也。”

13.脾中风者，翕翕发热，形如醉人，腹中烦重，皮目眴眴而短气。

【词解】

烦重：心烦而腹重，一解为腹重为甚。

【诠解】

本条是论脾中风的辨证。由于脾经风热，运化失职，阻滞气机，故腹中烦重。风热外束，故翕翕发热，面色红如醉酒状。风主动，故皮目为之**眴**动而短气。

【选注】

《金匱要略浅注》：“脾中风则周身翕翕发热，形如醉人，面赤，四肢俱软；腹中因风动火而烦；本气湿生而重，下上眼胞属脾胃，而名皮目风入而主动，则见**眴眴**；脾居肺肾之中界，病则懒于承上接下，天水不交而短气。”

14.脾死藏，浮之大坚，按之如复杯，洁洁状如摇者死。臣亿等详五藏各有中风中寒，今脾只载中风，肾中风、中寒俱不载者，以古文简乱极多，去古既远，无文可以补缀也。

【词解】

按之如复杯洁洁；形容脉象中空，如覆空杯，其中绝无涓滴之水。

【诠解】

本条是论述脾脏将死的脉候。脾胃气绝，不能运化水谷，饮食停聚，故脉浮取大坚。脾胃气散，阴津全无，故脉重按中空，而且躁疾不宁如摇者，故主死。

【选注】

《医宗金鉴》：“脾中风寒之邪，若脉见浮之大坚，失其和缓，按之状如覆杯，高章明洁，有力如摇，乃脾脏之死脏也。”

15.趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则坚，其脾为约，麻子仁丸主之。

麻子仁丸方

麻子仁二升 芍药半斤 枳实一斤 大黄一斤 厚朴一尺 杏仁一升
上六味，末之，炼蜜和丸梧子大，饮服十丸，日三，以知为度。

【词解】

约：当节约与约束讲。

【诠解】

本条是论述脾约的辨证论治。由于胃气强盛，故趺阳脉浮。脾脏津液不足，故趺阳脉涩滞而不流利。胃气强，伤于脾，脾阴弱，能食而不能运化，津液不能敷布，不能还入胃中，而反被迫下渗，则小便反数。胃燥而脾阴不濡，故大便难。胃强而脾弱，这是脾约证的病理特点。

治以麻子仁丸，泄热润燥，利气通便。方中大黄泄热通便，治胃气之强；芍药、麻子仁滋阴润燥，治脾阴之弱；枳实、厚朴理脾肺之气，以行津液；杏仁润燥，而利肺气，以通幽导便。

【选注】

《医宗金鉴》：“趺阳胃脉也，若脉涩而不浮，脾阴虚也，则胃气亦不强，不堪下矣。今脉浮而涩，胃阳实也，则为胃气强，脾阴亦虚也。脾阴虚不能为胃上输精气，水独下行，故小便数也；胃气强，约束其脾，不化津液，故大便难也。以麻仁丸主之，养液润燥，清热通幽。不敢恣行承气者，盖因脉涩终是虚邪也。”

16.肾著之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故，病属下焦，身劳汗出，衣一作表。里冷湿，久久得之，腰以下冷痛，腹重如带五千钱，甘姜苓术汤主之。

甘草干姜茯苓白术汤方

甘草 白术各二两 干姜 茯苓各四两

上四味，以水五升，煮取三升，分温三服，腰中即温。

【诠解】

本条是论述肾著的证治。肾被寒湿之邪滞着为病，由于身劳汗出，腠理开泄，衣里冷湿，寒湿之邪因而留着于肾之外府，所以腰中冷痛，其状如坐水中，或腰肿如水状，身体沉重，腹重如带五千钱。其人反不渴，小便自利，饮食如故，是说明此病为寒湿所着，滞而不去，是湿非水，而与水证鉴别。

本证是寒湿留着于腰部，病不在于肾之本脏，治宜甘姜苓术汤，温中散湿，健脾利水。方中干姜、甘草温中散寒，以补脾阳之衰；茯苓、白术驱湿外出，健脾以胜湿，俾正气旺而寒湿去，则肾著之病可愈。

【选注】

《金匱要略论注》：“腰为肾之腑，真气不贯，故冷如坐水中。形

如水状者，盖肾有邪则腰间带脉常病，故溶溶如坐水中，其不同之状，微胀如水也。药以苓、术、甘扶土渗湿为主，而以干姜一味温中去冷，谓肾之气不病，止在肾之外府，故治其外之寒湿而自愈也。若用桂附，则反伤肾之阴矣。”

【病案举例1】

谢某，女，30岁，患者于两年前足月生产第一胎时，胞衣滞留，当时屋冷身寒，历三时许，强努而下，汗出湿被。自此感腰以下冷痛，如坐水中，少腹重坠，小便不禁。素日议论水，想到水，洗身洗脸，过河逢水，室外下雨或闻水声，见小儿撒尿，茶壶倒水等，皆小便不能控制而自行排出。在当地多次检查泌尿系无器质性病变，久服调节神经类西药无效，昨晚坐浴后症状加重，小便滴沥不断，一夜未能离便盆，遂远途就诊。患者两年来形体衰弱，面色无华，神疲畏寒，饮食如故，大便正常，月事以时下。问诊间谈水即小便淋漓。切两脉寸关弦、尺沉虚，舌质正常，苔薄白布津。病属下焦虚寒，寒湿着而不去，故腰以下冷痛，肾阳虚惫，膀胱失约，故小便失禁。治宜肾着汤：

云苓20克，炒白术60克，炙甘草20克，干姜15克，制附子20克，水煎服。

复诊：述服上方三剂后，腰以下冷痛除，少腹已无重坠感。虽闻水声，见水时微有尿意，但已能控制。原方加益智仁30克、乌药12克。带药三剂喜归。最近信访，痼疾悉除，未见复发。

（摘自《山东中医学院学报》1980,3:64）

【病案举例2】

刘某，女，26岁。右侧腰与臀酸重疼痛，白带淋漓不断。切其脉沉迟，视其舌淡嫩而苔白。辨证：寒湿下注腰肾，脾阳不能温焙之证。

处方：干姜12克，白术12克，茯苓16克，炙甘草6克，续断10克，杜仲10克。

共服四剂，腰与臀酸痛愈，而带下减十之七八。

（刘渡舟治验）

17.肾死藏，浮之坚，按之乱如转丸，益下入尺中者，死。

【诠解】

本条是论述肾死脏的脉候。肾阴亏竭，真气不固，浮动于外，势将外脱，故脉浮取坚实，按之乱如转丸，有躁动不柔，下于尺部更为明显。此为肾之真脏脉现，故死。

【选注】

《医宗金鉴》：“肾中风寒之邪，若见浮之极坚，按之乱动有如转丸，及下入尺中，通然乱动，皆肾死真脏之脉也。”

18.问曰：三焦竭部，上焦竭善噫，何谓也？师曰：上焦受中焦气，未和，不能消谷，故能噫耳；下焦竭，即遗溺失便。其气不和，不能自禁制，不须治，久则愈。

【词解】

噫：暖气。

【论解】

本条是论述三焦气不和的辨证。三焦各部所属的脏腑生理功能衰退，如上焦心肺的功能衰退，而反出现暖出食气的中焦症状，其原因为上焦心肺功能衰退，气化失常，中焦脾胃精微之气，不能上达，陈腐之气聚于中焦，故中焦不能消化水谷，经常暖出食气。下焦肾、膀胱以及大小肠功能衰退，不能制约二便，或遗尿或大便失禁。但由于上焦心肺功能衰退，其气不和，荣不能内守，卫不能外固，下焦不能制约二便，出现遗尿，或大便失禁。本证不须治疗下焦，须待上焦心肺正气恢复，荣卫之气调和则愈。

上焦受气于中焦，下焦受气于上焦，中焦受气于下焦，三焦是相互作用、相互维系的。三焦发病，是相互影响、相互传变的。如上焦心肺的气血不和，可以引起中焦发病。上焦心肺血气不和，也可引起下焦发病。在治疗过程中，调和上焦心肺之血气，使五脏元真通畅，既能治疗中焦善噫，又能治疗下焦遗尿失便。在辨证过程中，要看其整体，考虑疾病的传变，认清疾病的局部和整体的关系，才能制订出全面的治疗原则。

【选注】

《医宗金鉴》：“若中焦虚竭，不能消化水谷，谷气不受，则上焦不相为用而失和也。失和则谷气郁而不宣，故善噫也。下焦虚竭，不能供升生之气于中焦，则失和也。失和则肾气独沉，自不能禁，故前遗溺而后失便也。”

19.师曰：热在上焦者，因咳为肺痿；热在中焦者，则为坚；热在下焦者，则尿血，亦令淋秘不通。大肠有寒者，多鹜溇；有热者，便肠垢；小肠有寒者，其人下重便血，有热者必痔。

【词解】

鹩：水鸟，其粪溏而不成形。又说鸭一名鹩。

【诠解】

本条是论述三焦的辨证。热在上焦，肺热燥火内盛，耗伤肺阴，肺叶不润，则为燥咳肺痿。热在中焦，脾胃热盛，伤津耗液不润大肠，故大便燥实坚硬。热在下焦，肾与膀胱热盛，迫血妄行，则为尿血。煎熬尿液，故尿少而赤疼，或热炼为砂淋、石淋与尿闭等证。

大肠有寒，水谷不分，则水粪杂下而为鹩溏。大肠有热，燥伤肠液，涩滞不行，称为肠垢，故大便脓血，黏滞而臭。小肠有寒，阳不化阴，湿浊停留，故下重便血。小肠有热，热向下注，蓄于肛门，则为痔。

【选注】

《医宗金鉴》：“热在上焦者，篇中所谓肺痿吐涎沫也。热在中焦者，篇中所谓腹满坚痛也。热在下焦者，篇中所谓小便淋沥也。其外大肠有寒者，多清彻鹩溏，即下利溏泻也。有热者，便稠粘肠垢，即下利脓血也。小肠有寒者，下重便血，即结阴便血也。有热者，热流于大肠，蓄于肛门，必病痔也。”

20.问曰：病有积、有聚、有**瘕**气，何谓也？师曰：积者藏病也，终不移；聚者府病也，发作有时，展转痛移，为可治；**瘕**气者胁下痛，按之则愈，复发，为**瘕**气。诸积大法：脉来细而附骨者，乃积也。寸口积在胸中；微出寸口，积在喉中；关上积在脐傍；上关上，积在心下；微下关，积在少腹。尺中，积在气冲；脉出左，积在左；脉出右，积在右；脉两出，积在中央，各以其部处之。

【词解】

瘕气：**瘕**，恐为谷之误，即食气。

【诠解】

本条是论述积聚**瘕**气的辨证，并说明积聚的脉诊。积病在脏，由于气郁血瘀，阴凝积结在脏，所以形成痞块，推之不移，痛有定处。聚病在腑，由于气郁而滞，感寒而聚，偏聚于腑，所以痛无定处，发作有时，推之能移。聚病其根不深，较积病易治。**瘕**气即食积之病，由于脾胃宿食停滞，胃壅肝郁，所以恶心暖气，腹满胁痛，按之则气流畅，疼痛缓和，但不久又气壅肝郁，胁下疼痛。

诊断积病的重要方法，脉来细而附骨，就是积病。因为气郁血瘀，阴凝积结在脏，所以气血荣卫不能上行而外达，脉来细而沉，好像附在骨上。可以根据脉沉细出现的部位，诊断积病的部位。如寸口脉沉细，积病在胸中；寸口微上脉沉细，积病在喉中；关位脉沉细，积病在脐旁；关位微上脉沉细，积病在心下；关脉微下脉沉细，积病在少腹；尺部脉沉细，积病在气冲；沉细脉象在左脉出现，积病在身体左侧；沉细脉象在右脉出现，积病在身体右侧；沉细脉象在左右两侧出现，积病在中央。治疗积病的立法处方，要根据不同部位，用不同的方法。

【选注】

《医宗金鉴》：“积者藏病，无时不有，不移其处也。聚者府病，发作有时，展转痛移也，为可治，谓府病易治也。滯气者，饮积胁下痛也，按之则止，不按复痛，以水气得按暂散，故痛暂止也。此即其证而言之。然诸积大法，尤当以诊候之也，脉来沉伏附骨而细者，乃诸积之诊也。若见两寸，积在胸中也；微出近鱼际，积在喉中也。两关，积在脐傍也；上关近寸，积在心下也；微下近尺，积在少腹也。尺中，积在气冲也；脉出左，积在左；脉出右，积在右；脉两出，谓左右俱见，积在中央也。各以其部之处，而诊积之所在也。”

结语

本篇主要是论述五脏风热，阴寒的辨证方法。所谓中风，代表阳证、实证。中寒代表阴证、虚证。可知风和寒是代表两类不同性质的疾病。五脏之风寒和真脏脉，说明在脏腑病机辨证过程中，一要辨准疾病的部位，二要辨清疾病的性质，三要辨明疾病的程度。

本病也论述肝着、肾着、脾约三种病的辨证论治方法。肝着非只肝病，是肝脉肺络郁滞之病，故治以旋覆花汤，活血通络，下气散结。肾着非只肾病，是寒湿留着于腰部，故治以甘姜苓术汤温中散湿，健脾利水。脾约非只脾病，是胃强约束脾阴之病，故治以麻子仁丸泄胃热，滋脾阴。以上三病的辨证论治，说明要掌握辨证论治的一般规律，也要掌握辨证论治的特殊规律。

本篇论述三焦辨证，说明上、中、下三焦相互为用，彼此制约，平衡协调的关系。

痰饮咳嗽病脉证并治第十二

概说

本篇共有条文四十一条，载方一十九首，附方一首。篇中从第一条至第十五条，皆有论而无方，重点论述了痰饮的分类，证候特点，以及治疗原则等，故可目之为本篇的总论。从第十六条至第三十二条，基本上是有论有方，针对痰、悬、溢、支、留诸饮进行了辨证论治，并指出了痰饮病的脉诊和预后，故可目之为本篇的各论。本篇论证精彩，铮铮有声，是古今治痰饮病的绝唱。

1.问曰：夫饮有四，何谓也？师曰：有痰饮，有悬饮，有溢饮，有支饮。

【词解】

痰饮：是指狭义的痰饮，为四饮之一。痰饮又称淡饮，形容清稀流动之状。

悬饮：是指水饮留于胁下，如同悬挂之物而不上不下，偏于一侧。

溢饮：是指水饮泛溢于外。

支饮：是指水饮结于心下两边，如树枝旁出，又解为支撑上逆之状。

【诠解】

本条是论述痰饮病分类。由于水饮停留的部位不同和主证不同，所以又分痰饮、悬饮、溢饮、支饮四种类型。

【选注】

《金匱要略论注》：“饮非痰，乃实有形之水也。其所因不同，所居不同，故有痰、悬、溢、支之分。悬者如物空悬，悬于膈上而不下也；溢者如水旁积，满盈而偏溢支体也；支者如果在枝，偏旁而不正中。痰饮者，亦即饮与涎相杂，久留不去者，其间或凝或不凝，凝者为

痰，不凝者为饮也。”

《医宗金鉴》：“夫饮有四，而此独以痰饮名。总之，水积阴或为饮，饮凝阳或为痰，则分而言之，饮有四，合而言之，总为痰饮而已。”

2.问曰：四饮何以为异？师曰：其人素盛今瘦，水走肠间，沥沥有声，谓之痰饮；饮后水流在胁下，咳唾引痛，谓之悬饮；饮水流行，归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重，谓之溢饮；咳逆倚息，气短不得卧，其形如肿，谓之支饮。

【词解】

素盛今瘦：指未病之前，身体丰满，已病之后，则身体消瘦。

沥沥有声：水饮在肠内流动时所发出的声音，同“漉漉有声”。

咳逆倚息：指咳嗽气逆不得平卧，只能倚物坐息。

【诠解】

本条是论述四饮的病机和主证。痰饮病是由于脾胃虚弱，不能运化精微，肺气不能敷布津液，而使饮食精微变成痰饮，若下流肠间，所以沥沥有声可闻。饮食精微化为痰饮，不得充养肢体，所以日见消瘦。

悬饮病是由于水饮形成以后，停留积聚在胁下，气机升降不利，所以咳唾时牵引胁肋疼痛。

溢饮是由于水饮形成之后，停积于内，泛溢于四肢体表，故身体疼痛而沉重。水邪郁滞，表闭不开，故不汗出。

支饮是水饮停留在心下的胸膈，水气凌肺，气失宣降，而咳逆倚息，不能平卧，气逆于上，饮停不化，故形如水肿。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“水性下走，而高原之水流入于川，川入于海。塞其川，则洪水泛滥，而人之饮水亦若是。《内经》曰：‘饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。’今所饮之水，或因脾土壅塞而不行，或因肺气涩滞而不通，以致流溢，随处停积。水入肠间者，大肠属金主气，小肠属火，水与火气相搏，气火皆动，故水入不得，流走肠间，沥沥有声，是名痰饮。然肠胃与肌肤合，素受水谷之气，长养而肥盛，今为水所病，故肌肉消瘦也。水入胁下者，属足少阳经，少阳经脉从缺盆下胸中，循胁里，过季肋之部分，其经多气属相火，今为水所积，其气不利，从火上逆胸中，遂为咳唾，吊引胁下痛，是名悬饮。水泛溢于表，

表阳也，流入四肢者，四肢为诸阳之本，十二经脉之所起，水至其处，若不胜其表之阳，则水散当为汗出，今不汗，是阳不胜水，反被阻碍经脉荣卫之行，故身体疼重，是名溢饮。水流入肠间，宗气不利，阳不得升，阴不得降，呼吸之息，与水迎逆于其间，遂作咳逆倚息短气不得卧。荣卫皆不利，故形如肿也，是名支饮。”

3.水在心，心下坚筑，短气，恶水，不欲饮。

【词解】

水在心：水，是指水饮。在心，是指水饮影响于心。

心下坚筑：是指心下痞坚，而又筑筑惕惕，悸动不安。

【诠解】

本条是论述水饮影响于心的辨证。水饮形成之后，停于心下，聚而动荡，上凌于心，内搏阳气，故心下坚筑。饮邪遏阻心阳，宗气滞而不畅，故见短气。阴寒凝聚，水饮内停，故恶水，不欲饮。

【选注】

《金匱要略论注》：“心主火，水逼之，故气收而筑，如相攻然。坚者，凝阴之象。短气，心气抑而宗气弱，则呼气自短也。恶水不欲饮，水本为火仇，水多则恶益增矣。”

4.水在肺，吐涎沫，欲饮水。

【诠解】

本条是论述水饮影响于肺的辨证。水饮形成之后，饮邪射肺，肺气激动水饮，水随气泛，故上吐涎沫。由于多吐涎沫，耗损津液，故又口干欲饮。

【选注】

《金匱要略心典》：“吐涎沫者，气火相激，而水从气泛也，欲饮水者，水独聚肺，而诸经失溉也。”

5.水在脾，少气身重。

【诠解】

本条是论述水饮影响于脾的辨证。水饮形成之后，饮邪困脾，中阳不运，湿浊不化，停于肢体，故身重。脾不运化，则气血不足，故少气倦怠。

【选注】

《金匱要略论注》：“脾主肌肉，且恶湿，得水气则濡滞而重，脾精不运，则中气不足，而倦怠少气矣。”

6.水在肝，胁下支满，噫而痛。

【词解】

支满：支撑胀满。

【诠解】

本条是论述水饮影响于肝的辨证。水饮形成之后，饮邪壅塞于肝，肝络不畅，故胁下支撑胀满，噫时引胁内痛。

【选注】

《金匱要略心典》：“肝脉布胁肋，水在肝，故胁下支满，支满犹偏满也。噫出于肺，而肝脉上注肺，故噫时则相引而痛也。”

7.水在肾，心下悸。

【诠解】

本条论述水饮影响于肾的辨证。水饮形成之后，饮邪犯肾，肾不主水，水饮上逆，水气凌心，故心下悸动。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“心属火而宅神，畏水者也。今火在肾，肾水愈盛，上乘于心，火气内郁，神灵不安，故作悸动，筑筑然惧也。”

8.夫心下有留饮，其人背寒，冷如水大。

【诠解】

本条是论述留饮的辨证。水饮形成之后，饮邪留于心下，困阻心阳，则使阳气不布，不能温暖背部的心俞，故病人背寒冷如水大。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“心之俞出于背，背阳也。心有留饮，则火气不行，惟是寒饮注其俞，出于背。寒冷如掌大，论其俞之处，明其背之非尽寒也。”

9.留饮者，胁下痛引缺盆，咳嗽则辄已一作：转甚。

【诠解】

本条是论述留饮的辨证。饮成之后，若留于胁下，肝络闭阻，壅塞不通，阻碍阴阳升降之机，故胁下痛引缺盆。咳嗽之时，气满更甚，故

咳嗽则胁痛加重。

【选注】

《金匱要略直解》：“缺盆者，五脏六腑之道，故饮留于胁下，而痛上引缺盆。引缺盆则咳嗽，咳嗽则痛引胁下而转甚，此属悬饮。”

10.胸中有留饮，其人短气而渴，四肢历节痛，脉沉者，有留饮。

【论解】

本条论述胸中留饮的两种变化。水饮停留在胸中，压抑肺气，故其人短气。肺气不利，气不布津，故又口渴。

饮邪留于胸中，渐渐增多，又流于四肢，而使关节气血痹着不通，则四肢历节疼痛。凡有留饮，必滞于气，故其脉沉。沉脉主气郁，又主水结，故可一脉两断。

【选注】

《金匱要略悬解》：“饮阻窍隧，肺无降路，津液凝滞，故短气而渴。湿流关节，故四肢关节烦痛，此饮之自胸膈而流四肢者，所谓溢饮也。”

11.膈上病痰，满喘咳吐，发则寒热，背痛腰疼，目泣自出，其人振振身𦨇剧，必有伏饮。

【词解】

目泣自出：指痰喘剧咳，气逆而甚，则使眼泪自出。

振振身𦨇剧：形容咳时身体努动振振而摇，坐立不稳之状。

伏饮：水饮潜伏于内，而有巢囊，不易治愈。

【论解】

本条是论述膈上伏饮的辨证。膈上有伏饮，又外感风寒，闭塞肺气，则使伏饮加重，饮邪射肺，故胸肺胀满，喘息咳嗽，呕吐痰涎，咳喘胀满，肺气不胜其扰，则目泣自出。风寒束于外，水饮动于中，阳气不得宣通，故发热恶寒，背痛腰疼，身体振振𦨇动而剧。

【选注】

《金匱要略浅注》：“饮留而不去，谓之留饮。伏而难攻，谓之伏饮。膈上伏饮之病，时见痰满喘咳，病根已伏其中，一值外邪暴中，其内饮与外邪相援，一时吐露迅发，则以外邪之为寒热，背痛，腰疼；激

出内饮之痰满喘咳大作，以致目泣自出，其人振振身^咽堵剧，因以断之曰，必有伏饮。俗谓哮喘，即是此证。”

12.夫病人饮水多，必暴喘满，凡食少饮多，水停心下，甚者则悸，微者短气。

脉双弦者寒也，皆大下后喜虚；脉偏弦者饮也。

【词解】

脉双弦：是指两手寸口脉俱弦。

偏弦：是指一手寸口脉弦。

【诠解】

本条是论述痰饮的病因和辨证。由于食少饮多，水液内停，聚而为饮，水饮上逆于肺，故轻微者，仅见短气。重者暴发喘满。水饮重者，停于心下，上凌于心，故心悸。痰饮之邪多停留于一处，故常见一侧脉弦。脉双弦者，阴气盛也，为寒疝之疾。又往往由于大下之后，脾胃虚寒，导致全身虚寒，则脉双弦。

【选注】

《金匱要略心典》：“饮水过多，水溢入肺者，则为喘满，水停心下者，甚则水气凌心而悸，微则气被饮抑而短也。双弦者，两手皆弦，寒气周体也。偏弦者，一手独弦，饮气偏注也。”

13.肺饮不弦，但苦喘短气。

【诠解】

本条是论述肺饮的辨证。由于肺气不化，不能通调水道，水饮之邪上停于肺，肺气受阻而不利，故但苦喘短气。肾阳尚能温和，又无风寒外束，仅有肺中微饮，故脉来不弦。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“脉弦为水为饮，今肺饮而曰不弦，何也？水积则弦，未积则不弦，非谓肺饮尽不弦也。此言饮未积，犹得害其阳，虽不为他病，亦适成其苦喘短气也。”

《金匱要略心典》：“肺饮，饮之在肺中者，五脏独有肺饮，以其虚而能受也，肺主气而司呼吸，苦喘短气，肺病已著，脉虽不弦，可以知其有饮矣。”

14.支饮亦喘而不能卧，加短气，其脉平也。

【词解】

脉平：谓平和之脉。

【诠解】

本条是论述支饮的辨证。支饮轻证，未伤脉络，故其脉平。饮邪支撑，上附于肺，肺气不能宣降，故短气，喘而不能卧。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“脉平当无病，何以有病而反平也，正与不弦意同，明其虽有支饮，而饮尚不留伏，不停积，以其在上焦，未及胸中，不伤经脉，故脉平，然碍其阴阳升降，故喘不能卧短气耳。”

【诠解】

15.病痰饮者，当以温药和之。

本条是论述痰饮病的治疗大法。痰饮的形成，是由于胃虚，不能游溢精气，上输于脾；脾虚不能散精，上归于肺；肺虚不能通调水道，下输膀胱；肾阳虚弱，不能化气行水。水精不能四布，水湿停留，积为水饮。水饮多在肺、脾、肾所虚之处，停留为患。总之，人体内水液流行因虚而停，因寒而凝，聚成痰饮，病变多端。治宜温药和之，温药可化水饮为气，可使水气流行，水饮消散，津液布达，以致和平。用温药暖脾胃，可以运化；温暖肺气，可以通调水道；温暖肾阳，可以化气，则水液按其常度流行，不停不聚，痰饮无由而生。

痰饮病为阳不化阴，本虚标实之病。若久用温补，则滞腻而不去；若久用燥热，则结而不散；若久用寒凉，则饮凝越多；若久用泻下，水饮虽可暂去，而脏腑亦虚，导致饮去而复聚。故痰饮病的重要治疗大法，是当以温药和之。至于寒凉补泻等法，可暂用一时，实非长久之计。仲景提出治以温药和之的原则，治缓而力专，正邪兼顾，是耐人寻味的。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“痰饮由水停也，得寒则聚，得温则行，况水从乎气，温药能发越阳气，开腠理，通水道。”

《金匱要略方论本义》：“言和之，则不啻事温补，即有行消之品，亦概其义例于温药之中，方谓之之和之，而不可谓补之益之也。盖痰饮之邪，因虚而成，而痰亦实物，必可有开导，总不出温药和之四字，其法尽矣。”

《金匱悬解》：“痰饮水寒土湿，火凉金寒，精气堙郁所作，当以

温药和之，寒消湿化，自然涣解。盖土不得火，湿气滋生，此痰饮化生之原也。土湿则土不生金，痰凝于心胸，下不制水，饮聚于肠胃，肺冷故气不化，水熏蒸而为痰，肾寒故水不化气，停痰而为饮，是以当温也。”

16.心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之。

茯苓桂枝白术甘草汤方

茯苓四两 桂枝 白术各三两 甘草二两

上四味，以水六升，煮取三升，分温三服，小便则利。

【诠解】

本条是论述痰饮的证治。由于心胸之阳气不振，不能温化水饮，而脾胃虚弱，又不能运化水湿，痰饮之邪留于心下不去，所以胸胁支满。饮邪上犯，清阳不升，所以头目眩晕。

治以苓桂术甘汤，温阳化气，健脾利水。方中桂枝温阳，化气行水；白术健脾运湿；甘草和中益气；茯苓淡渗利水，通畅三焦。本方温暖心脾之阳，以化水饮之邪，是用温药治饮的代表方。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“此痰饮之在胃，而痞塞阻碍及于胸胁，甚至支系亦苦满，而上下气行愈不能利，清阳之气不通，眩晕随之矣。此虽痰饮之邪未尝离胃，而病气所侵，已如斯矣。主之以苓桂术甘汤，燥土升阳，导水补胃，化痰驱饮之第一法也。胃寒痰生，胃暖则痰消也。脾湿饮留，胃燥则饮祛也。可以得此方之大义用之诸饮，亦无不行矣。”

【病案举例】

陈某，女，65岁。素有痰嗽旧疾，饱食后与人垢詈不胜，眊然而踣，不省人事，抬至家中，更医多人，迄未得效……1979年9月10日初诊，病者面色黯青，昏不知人，时太息，胸腹膨隆，呖声频频，唇部眊动不息，牙关微紧，脉细弦若丝，启口视舌，舌苔腻，质暗红，此为痰浊食积滞塞中脘为恙也。

俾用瓜蒂散1.4克、麝香0.15克调匀灌服，越二时许，吐出酸腐积食，杂以大量痰涎，泄下痰沫甚夥。翌日二诊时，人事已清，且能啜

粥。觉气短，心悸而喘，起坐则头眩欲仆。脉细弦，苔腻而斑剥。盖吐后脾胃气伤，健运失职，水湿内停，上冲为眩，凌心则悸，冲肺作喘。治以扶阳涤饮法：

茯苓30克，桂枝15克，白术12克，甘草10克，六剂而安。

（摘自《中医杂志》1981,12:21）

17.夫短气有微饮，当从小便去之，苓桂术甘汤主之方见上。肾气丸亦主之方见妇人杂病中。

【词解】

微饮：是指轻微的痰饮。

【诠解】

本条论述痰饮病的辨证论治。由于阳虚而不能化气行水，心脾气弱，不能运化水湿，而使微饮内留，妨碍升降之机，所以常有短气之证。用苓桂术甘汤，温化中焦，使水邪从小便排出。若为肾阳虚弱，不能温阳化气，小腹拘急不仁，而小便不利，或见畏寒肢冷，用肾气丸温养肾气，以助气化，而利水消饮。痰饮的由来多是肺、脾、肾的气化不及所致，然治疗方法，应有侧重。苓桂术甘汤是侧重于脾，而肾气丸则是侧重于肾。

【选注】

《金匱要略心典》：“气为饮抑则短，欲引其气，必蠲其饮。饮，水类也，治水必自小便去之，苓桂术甘盖土气以行水，肾气丸养阳气以化阴，虽所主不同，而利小便则一也。”

《金匱要略浅注补正》：“有饮者，必短气，诚以水化则为气，水不化则气不生，故呼出之气短也；水停则阻气，水不化则气不降，故吸气短也。水饮重者，则兼有咳满等证；若但短气而不兼咳满等证者，为饮未透，但有微饮而已。凡水饮皆当利小便，此短气也，尤属水停不化，亟当从小便而利去之也。”

18.病者脉伏，其人欲自利，利反快，虽利，心下续坚满，此为留饮，欲去故也。甘遂半夏汤主之。

甘遂半夏汤方

甘遂大者，三枚 半夏十二枚 以水一升，煮取半升，去滓 芍药五枚 甘草如

指大一枚，炙一本作无

上四味，以水二升，煮取半升，去滓，以蜜半升，和药汁煎取八合，顿服之。

【词解】

欲自利：病人未经攻下而欲要下利。

利反快：是指下利之后，病人感觉症状轻快。

【诠解】

本条论述留饮的证治。留饮，指饮邪留于心下不解，饮留则气滞而脉道不利，故脉则伏。若正气拒饮欲从下去，故其人欲自利，因利则心下坚满而反快，可知饮有下解之势。但留饮已有巢穴可据，不能得下即去，故又心下续坚满。治宜因势利导，采通因通用之法，以甘遂半夏汤泻下而除。方中甘遂攻逐水饮，通利二便；半夏散结除痰；芍药敛阴液，去水气；白蜜、甘草缓中解毒，安中和胃。甘草与甘遂相反，合而用之，可增加攻逐水饮的功效。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“病者脉伏，为水邪所压混，气血不能通，故脉反伏而不见也。其人欲自利，利反快，水流湿而就下，以下为暂泄其势，故暂安适也。然旋利而心下续坚满，此水邪有根蒂以维系之，不可以顺其下利之势而为削减也，故曰此为留饮欲去故也。盖阴之气立其基，水饮之邪成其穴，非开破导利之不可也。主之以甘遂半夏汤，甘遂以驱邪为义，半夏以开破为功，而俱兼燥土益阳之治；佐以芍药收阴，甘草益胃，更用蜜半升和药汁，引入阴分，阴邪留伏之处而经理之，八合顿服之，求其一泄无余也。”

19.脉浮而细滑，伤饮。

【词解】

伤饮：指被饮所伤。

【诠解】

本条论初伤于饮的脉象。此证因外证未解，若饮水过多，水气不行，在中则心下必悸；在下小便不利，必苦里急。脉浮主表有邪，细而滑则主内伤于饮。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“脉浮而细，即弦也，兼滑，饮中有痰

也，此痰饮之脉也，但在胃不浮矣，浮不在胃也。”

《金匱要略心典》：“伤饮过多也，气资于饮，饮多反伤气，故脉浮而细滑，则饮之微也。”

20.脉弦数，有寒饮，冬夏难治。

【诠解】

本条论述寒饮冬夏难治之脉。由于寒饮内停，故脉弦。寒饮久郁，郁阳化热，故脉数；冬季寒冷，饮邪加重，欲温其寒，不利于热；夏季炎热，郁热加重，欲清其热，不利于饮。故曰：冬夏难治。

【选注】

《金匱要略论注》：“脉数弦者，当下其寒，可知弦数之脉，为阳中有阴，故曰有寒饮。病既阳中有阴，值大寒大热，病气复因时令而变，东垣所谓复病也。复病深而易感，故曰冬夏难治。”

《金匱要略心典》：“脉弦数而有寒饮，则病与脉相左，魏氏所谓饮自寒而挟自热是也。夫相左者，必相持。冬则时寒助饮，欲以热攻，则脉数必甚；夏则时热助脉，欲以寒治，则寒饮为碍，故曰难治。”

21.脉沉而弦者，悬饮内痛。

【词解】

内痛：指胁内疼痛。

【诠解】

本条论述悬饮的脉证。悬饮结在胁下，胁主里，故脉沉，弦主饮，故脉沉而弦。悬饮在胁，困郁脉络，故胁内有牵引性疼痛。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“脉沉病在里也，凡弦者为痛，为饮，为癖。悬饮结积，在内作痛，故脉见沉弦。”

22.病悬饮者，十枣汤主之。

十枣汤方

芫花熬 甘遂 大戟各等分

上三味，捣筛，以水一升五合，先煮肥大枣十枚，取八合，去滓，

内药末，强人服一钱匕，羸人服半钱，平旦温服之，不下者，明日更加半钱，得快之后，糜粥自养。

【诠解】

本条论述悬饮的治法。饮邪结实，僻于胁下，故用十枣汤破结逐水。方中大戟泻脏腑水湿；芫花散水饮结聚；甘遂泻经络水湿；大枣十枚，调和诸药，缓解药毒，使峻下之后不伤正气。大戟、芫花、甘遂三药为末，每服2~3克，一日一次，清晨空腹，浓煎枣汤调下。

【选注】

《金匱要略论注》：“十枣汤者，甘遂性苦寒，能泻经隧水湿，而性更迅速直达；大戟性苦辛寒，能泻脏腑之水湿，而为控涎之主；芫花性苦温，能破水饮窠囊，故曰被癖须用芫花。合大枣用者，大戟得枣，即不损脾也。盖悬饮原为骤得之证，故攻之不嫌峻而骤；若稍缓而为水气喘急浮肿。《三因方》以十枣汤，药为末，枣肉和丸以治之，可谓善于交通者也。”

【病案举例】

宋某，男，40岁。患胸腔积水，经过多次引流放水，但时放时生。病人全身虚胖，行动气喘，自谓右胸连胁，痛胀不舒，不能深呼吸及右侧睡卧，大便时干。按诊后以十枣汤治之，当时以大枣煨烂后去皮核将药末包入，每天服药一次，三味药末等量，总量不超过一钱，服一周。据病人反映，每次药后二小时，即开始腹泻腹痛，初带粪便，后段即纯下稀水，便后胀痛见轻，余嘱令继服，又一周，下水仍同前，胸胁胀痛已不明显。再令服至十六天时，泻下物已为粪便，不见稀水，乃令停药观察，症状消失，恢复上班工作。

（摘自《北京中医学院学报》1981,1:21）

23.病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之，小青龙汤亦主之。

大青龙汤方

麻黄六两，去节 桂枝二两，去皮 甘草二两，炙 杏仁四十个，去皮尖 生姜三两 大枣十二枚 石膏如鸡子大，碎

上七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，取微似汗，汗多者，温粉粉之。

小青龙汤方

麻黄去节，三两 芍药三两 五味子半升 干姜三两 甘草三两，炙 细辛三两 桂枝三两，去皮 半夏半升，汤洗

上八味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

【诠解】

本条是论溢饮的证治。水饮之邪不散，若外溢于肌表四肢，郁遏荣卫之气，故身体疼重而无汗。饮邪停留体表，故当发其汗，使水饮从汗而解。

大青龙汤治溢饮而兼热证，小青龙汤治溢饮而兼寒证。大青龙汤方用麻黄汤的麻黄、桂枝、杏仁、甘草发汗宣肺，以散水气；生姜、大枣调和脾胃，而利营卫；石膏清解阳郁之热。

小青龙汤方用麻黄、桂枝发汗散饮，宣肺行津；干姜、细辛、半夏温中化饮，散寒降逆；五味子收敛肺气；芍药敛阴护正；甘草和药守中。大青龙汤治溢饮，而兼烦躁；小青龙汤治溢饮而兼咳喘。

【选注】

《金匱要略编注》：“此出溢饮之方也。溢饮者，风寒伤于胸膈，表里气郁不宣，则饮水流行，归于四肢，皮肿满，当汗出而不汗出，身体疼重，此表里风寒两伤。偏于表寒多者，故以麻桂二汤去芍药加石膏，为大青龙，并驱表里之邪，石膏以清风化之热，使阳气通而邪从汗解，饮从下渗；或因寒邪而偏伤于内，脾胃气逆，痰饮溢出躯壳肌肉之间，浮肿疼重者，当以小青龙汤逐痰解表，使内之饮无地可容，故小青龙汤亦主之。”

【病案举例1】

陈某，男，44岁，医生。1976年12月6日初诊，诊断：哮喘性支气管炎。起始两侧鼻腔作痒、喷嚏频作、鼻流清涕，继而咳喘痰鸣，胸闷气短，咯大量泡沫样痰，夜间尤甚，不能平卧。两肺听诊：满布哮鸣音。曾屡用强的松、扑尔敏、抗生素及胎盘组织液等治疗，不能奏效，乃停用西药，求治于中医。辨证属寒饮伏肺，累及肺肾，升降气机失调，拟予温肺化饮为主，参以温肾纳气之品，选用小青龙汤。

处方：麻黄9克，桂枝9克，白芍15克，干姜4.5克，细辛15克，五味子9克，制半夏9克，甘草6克。3剂。另用紫河车研末，空心胶囊装。

每服9克，1日3次，连续服用3个月。

药后症状基本控制，继服中药7剂。后随访两个冬天，病情未作，基本痊愈。

（摘自《上海中医药杂志》1980,4:38）

【病案举例2】

吕某，男，46岁。

四肢肿胀酸痛已十余日。仰手诊脉为之吃力，西医诊为神经炎，注射维生素无效。视其人身体魁梧，面色鲜泽。舌红而苔腻，脉浮且大，按其手足有凹陷。自称身上经常出汗，惟手足不出。

辨证：脉浮为表，大为阳郁，《金匱要略》云：“饮水流行，归于四肢，当汗出而不汗出，身体酸重，谓云溢饮。”又说：“病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之。”此证四肢肿胀，脉又浮大，为“溢饮”无疑。遂用大青龙汤加薏米、茯苓皮，服两剂而瘳。

（刘渡舟治验）

24. 膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧，得之数十日，医吐下之不愈，木防己汤主之；虚者即愈，实者三日复发，复与不愈者，宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之。

木防己汤方

木防己三两 石膏十二枚，鸡子大 桂枝二两 人参四两
上四味，以水六升，煮取二升，分温再服。

木防己加茯苓芒硝汤方

木防己 桂枝各二两 芒硝三合 人参 茯苓各四两
上五味，以水六升，煮取二升，去滓，内芒硝，再微煎，分温再服，微利则愈。

【词解】

面色黧黑：是指面色黑兼黄。

虚者：指心下痞坚变为柔软。

实者：是指心下仍然痞坚，病根未去。

【诠解】

本条是论述支饮的证治。膈间有支饮，水饮上逆于肺，故咳喘胸满。饮邪聚结于中，故心下痞坚。寒饮凝聚于里，阳气不得外达，营卫运行不利，故面色黧黑；水饮内结，故脉沉紧。本证得之数十日之久，医见心下痞，而用吐下之法不愈。此为支饮在于膈间，虚实皆有，病情复杂。

治用木防己汤，行水散结，补虚消痞。方中木防己辛温，通结气，散留饮；桂枝温通经脉，温化水饮；石膏清除伏郁之阳热；人参补肺脾之气，恢复久病吐下之虚损。四药合用，可以温化水饮，消散痞坚，降逆平喘，扶正补虚。

服木防己汤之后，痞坚消散，变成柔软，为病已愈。若药后心下仍然痞坚，几日后复发，再用本方不愈者，可用木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤。本方加芒硝者，软坚以破凝结之邪；加茯苓者，行水化饮，导水下行；去石膏者，避其气寒而尽防己、桂枝温通之用。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“心肺在膈上，肺主气，心主血，今支饮在膈间，气血皆不通利，气不利，则与水同逆于肺而发喘满。血不利，则与水杂揉，结于心下而为痞坚。肾气上应水饮，肾水之色黑，故黧黑之色见于面也。脉沉为水，紧为寒，非别有寒邪，即水气之寒也。医虽以吐下之法治，然药不切于病，故不愈。用木防己者，味辛温能散留饮结气，又主肺气喘满，所以为主治。石膏味辛甘微寒，主心下逆气，清肺定喘，人参味甘温补心肺气不足，皆为防己之佐，桂枝辛热，通血脉开结气，且支饮得温则行，又宣导诸药，用之为使，若邪客之浅，在气分而多虚者，服之即愈。若邪客之深，在血分多而实者，则愈后必再发。以石膏为气分之药，故去之，芒硝味咸寒为血分药，能治痰结，去坚消血癖，茯苓伐肾邪，治心下坚满，佐芒硝则行水之力益倍，故加之。”

【病案举例】

俞某，男，56岁，农民。于1978年2月2日诊治。

患者慢性咳嗽史已10年，遇冷天更甚，面色黧黑，精神疲乏，咳嗽气逆近日增剧，痰呈泡沫样，头昏且晕，畏寒，纳差脘胀，时觉呕恶，呕吐痰涎，眼胞浮肿，唇紫，舌质红苔薄白腻，脉象浮大而软。检查：慢性病容，桶形胸，两肺呼吸音低，粗糙，两下肺闻及湿性啰音，心无

异常发现，胸透肺纹理增深，横膈下降，双肺透光度增强，诊断：气管炎，肺气肿。此属痰饮，治以木防己汤加味：

桂枝、制半夏、东白芍、百部、石膏各10克，党参30克，防己15克，干姜、五味各5克，服五剂后，呕吐已止，肿胀已除，前方继服7剂，病情显著缓解。

（摘自《成都中医学院学报》1979,3:71）

25.心下有支饮，其人苦冒眩，泽泻汤主之。

泽泻汤方

泽泻五两 白术二两

上二味，以水二升，煮取一升，分温再服。

【词解】

冒眩：冒，阴浊蔽住清阳。眩，目中生黑花，而有眩晕之意。

【诠解】

本条是论述支饮发生眩冒的证治。由于脾胃虚弱，不能运化水湿，饮邪停于心下，上乘清阳之位，所以头目昏冒，痛苦已极。

治以泽泻汤，健脾行饮，消阴通阳。方中白术健脾益气，运化水湿，升清降浊；泽泻利水消饮，降浊消阴。

【选注】

《金匱要略论注》：“支饮在心下，虽不正中而近心，则心火为水气所蚀。心者君火，为阳气之宗，所谓火明外视，阳气有权也；饮气相蚀，阴气盛而清阳阻抑，又适与气道相干，故冒眩。冒着，如有物蒙之也；眩者，目见黑也。肾为水之源，泽泻味咸入肾，故以之泻其本而标自行。白术者，壮其中气，使水不复能聚也。然以泽泻泻水为主，故曰泽泻汤。”

【病案举例】

魏某，男，60岁，河南人。患头晕目眩，兼有耳鸣，鼻亦发塞，嗅觉不佳。病有数载，屡治不效，颇以为苦。切其脉弦，视其舌则胖大无伦，苔则水滑而白。

辨证：此证心下有饮，上冒清阳，是以头冒目眩，其耳鸣、鼻塞，

则为浊阴踞上，清窍不利之所致。

治法：渗利水饮之邪。

方药：泽泻24克，白术10克。

此方服一剂而有效，不改方，共服5剂，则头晕、目眩、耳鸣、鼻塞等症愈其大半，转方用五苓散温阳行水而收全功。

（摘自《中医杂志》1980,9:18）

26.支饮胸满者，厚朴大黄汤主之。

厚朴大黄汤方

厚朴一尺 大黄六两 枳实四枚

上三味，以水五升，煮取二升，分温再服。

【诠解】

本条是论述支饮胸满的证治。痰饮结聚，郁而化热，饮热郁蒸，散漫胸间，所以胸满；若饮热郁于胃肠，胃肠气滞不通，故腹满疼痛。

本证为支饮，又挟有湿热蕴结于胸腹，故治以厚朴大黄汤，理气散满，疏导胃肠。方中厚朴降气，枳实理气，开滞消痞；大黄之量最重，泻胃肠之滞热，泻水饮有形之邪气。本方以枳实、厚朴利气行饮，推荡向下，又用大黄疏导胃肠，泻下而去，可收痰饮湿满并治之功。

【选注】

《金匱要略浅注》：“此节指支饮在胸，进一层立论。云胸满者，胸为阳位，饮停于下，下焦不通，逆行渐高，充满于胸故也。主以厚朴大黄汤者，是调其气分，开其下口，使上焦之饮，顺流而下。厚朴、枳实皆气分之药，能调上焦之气，使气行而水亦行也，继以大黄之推荡，直通地道，领支饮以下行，有何胸满之足患哉。此方药品与小承气同，其分量、主治不同，学者宜体认古人用药之妙。”

27.支饮不得息，葶苈大枣泻肺汤主之方见肺痈中。

【诠解】

本条是论述支饮不得息的证治。支饮阻于胸膈，肺气不利，痰涎壅塞，则胸满咳喘，呼吸困难。

治以葶苈大枣泻肺汤，专泻肺气，而逐痰饮。方中葶苈子泻肺下

气，破水逐饮，令肺气通降，则气行水降；大枣安中，补气血，益津液，以杜泻下之虚，本方泻肺治水，虽峻而不伤正。

【选注】

《金匱要略编注》：“此支饮偏溢于肺也。支饮贮于胸膈，上干于肺，气逆则呼吸难以通彻，故不得息。然急则治标，所以佐大枣之甘养胃和中以保脾，葶苈之苦以泻肺，俾肺气通调，脾得转输，为峻攻支饮在肺之主方也。

28.呕家本渴，渴者为欲解，今反不渴，心下有支饮故也。小半夏汤主之《千金》云：小半夏加茯苓汤。

小半夏汤方

半夏一升 生姜半斤

上二味，以水七升，煮取一升半，分温再服。

【诠解】

本条论述支饮呕吐的证治。胃有饮邪，气不和降，则呕吐。若饮邪吐尽，胃阳得复，故口渴。口渴为饮邪已去，胃气已复，故曰“渴者为欲解”。若呕吐不尽，饮邪仍在胃中，而胃阳不复，故口不渴。此为心下有支饮，故治宜小半夏汤。方中生姜辛散走窜，温化寒凝，消散水饮，饮去则胃和呕止；半夏涤痰行水，降逆止呕。

【选注】

《金匱要略心典》：“此为饮多而呕者言。渴者饮从呕去，故欲解；若不渴，则知其支饮仍在，而呕亦未止。半夏味辛性燥，辛可散结，燥能蠲饮；生姜制半夏之悍，且可散结止呕。”

【病案举例】

患者郝某，男，65岁。呕吐频繁，而口不渴，所吐皆为痰涎之物。脉弦而滑，舌苔白滑且腻。辨为胃中有饮。

处方：半夏15克，生姜15克，陈皮10克。一剂即愈。

（刘渡舟治验）

29.腹满，口舌干燥，此肠间有水气，己椒苈黄丸主之。

防己椒目葶苈大黄丸方

防己 椒目 葶苈熬 大黄各一两

上四味，末之，蜜丸如梧子大，先食饮服一丸，日三服，稍增，口中有津液，渴者加芒硝半两。

【诠解】

本条论述肠间有水气的证治，由于脾胃不能运化水湿，肺气不能通调水道，水饮停滞，走于肠间，故腹中胀满，而沥沥有声可闻。水走肠

间，津液不能上承，所以口干舌燥。

治以己椒蒴黄丸，分消水饮，导邪下出。方中防己宣通肺气，通调水道，下利水湿；葶苈子泻肺下气，使水气下行；椒目利水逐饮；大黄通利大便，攻逐实邪从大便而出。本方能通利水道，攻坚决壅，前后分消，则诸证自愈。方后自注云：“日三服，稍增，口中有津液，渴者，加芒硝半两”，说明运化通调之职，稍有恢复，故口中有津液。但水饮结聚未去，加芒硝以破水饮结聚。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“肺与大肠，合为表里。肺本通调水道，下输膀胱，仅从其合，积于肠间，水积则金气不宣，**臌**郁成热为腹满，津液遂不上行，以成口干舌燥。防己、椒目、葶苈，皆能利水，行积聚结气。而葶苈尤能利小肠，然肠胃水谷之气，若腹满者，非轻剂所能治，加大黄以泻之。”

【病案举例】

傅刘氏，年35岁，因患闭经，延医数人，有按瘀血论治者，有从血亏论治者，有从气血双虚而治者，医治年余，经未行而身体日衰。患者素体健壮，曾因怒气而逐渐食少，形瘦腹大，经闭，腹内漉漉有声，对坐即能听到。自言腹满甚，口干舌燥，舌淡苔薄白，双手脉均沉细而弦。脉症合参，证属痰饮阻经。给予己椒蒴黄丸方：

防己10克，川椒目15克，炒葶苈子10克，大黄10克（后入），水煎服二剂。

服药后当晚泻下痰液水一瓷脸盆余，泻后除感乏力外，反而有腹中舒适与饥饿感，脉弦象亦减。余曰：药已中病，隔日再服一剂。

二诊：患者两次泻下后（第二次泻之痰水为前次的一半）身感舒适，饮食增加。宗“衰其大半而止”之旨，嘱停药后以饮食调养。月后随访，经血已通，康复如前。

（摘自《山东中医学院学报》1980,1:54）

30.卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者，小半夏加茯苓汤主之。

小半夏加茯苓汤方

半夏一升 生姜半斤 茯苓三两一法四两

上三味，以水七升，煮取一升五合，分温再服。

【词解】

卒呕吐：突然呕吐。

眩悸：是指头昏目眩，心悸而不安。

【诠解】

本条论述痰饮眩悸的证治。饮邪停于胃中，故心下作痞；水饮之气上逆，故卒然呕吐；水饮上逆，凌于心则悸；水邪蔽于清阳，则头目眩晕。

治以小半夏加茯苓汤，行水散痞，引水下行。方中生姜、半夏温化寒凝，行水散饮，降逆止呕；茯苓健脾益气，渗利水湿，导水下行，而有降浊升清之功。

【选注】

《金匱要略心典》：“饮邪逆于胃则呕吐，滞于气则心下痞，凌于心则悸，蔽于阳则眩。半夏、生姜止呕降逆，加茯苓去其水也。”

【病案举例1】

黄某，女，41岁，工人。1974年6月14日初诊。

自诉于1973年3月起，每夜入寐不久，即起床独步梦游里许路程而返，或途中偶然惊醒折回，严重时一夜间梦游竟达四五次之多。曾服养心安神之剂经年无效，近月来呃逆频作，寐食几废，痛苦万状。望其面容苍黄，肌肤甲错，毛发枯黄，两目无神，舌淡，苔白湿润，呃声短弱，脉濡细无力。

审其脉证，属心脾两亏，精血虚耗，心肾不交，神不守舍。但为何屡进养心安神之剂不但无效，反而呃逆频作？沉思良久，才恍然有悟，盖中虚脾失健运，痰浊内生，补益滋腻之品最易与痰浊胶结，壅滞气机，致使胃失和降而上逆。然呃逆乃是病标，心脾两亏，肾精虚空，心肾不交，神不守舍为病本。治疗当标本兼顾，治标应力避香燥，以免加重标病。方选《金匱》小半夏加茯苓汤加味：太子参30克，姜半夏12克，茯苓24克，枇杷叶9克，白蜜30克（冲），姜汁少许。连服六剂。

二诊：上方服后呃逆大减，食欲增进，精神愉快。标病好转，胃得和降，转以图本为主。方拟：大枣18克，甘草9克，浮小麦30克，太子参30克，半夏9克，茯苓15克，远志6克，杞子15克，女贞子15克，菟丝子15克，连服四剂。

三诊：呃逆全止，寐安神宁，梦游四天内发一次，此后继服上方三十余剂，梦游痊愈。随访至今未见复发。

（摘自《广西中医药》1980,1:36）

【病案举例2】

袁某，男，37岁。患高血压病，头目眩冒，呕吐时发，心悸，腕部作痞。脉弦滑，舌苔白滑。

辨证：呕吐、悸、眩、痞四证俱见，此乃膈间水饮也。

处方：半夏15克，茯苓30克，生姜15克。

服三剂病减轻，又服三剂痊愈。

（刘渡舟治验）

31.假令瘦人，脐下有悸，吐涎沫而癫眩，此水也，五苓散主之。

五苓散方

泽泻一两一分 猪苓三分，去皮 茯苓三分 白术三分 桂二分，去皮
上五味，为末，白饮服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈。

【词解】

瘦人：是指其人素盛今瘦而言。

脐下有悸：水气相搏于下，故脐下悸动。

癫眩：癫同颠，是指病人头目眩晕。又解，本证可令人昏冒扑地，所以叫癫眩。

【诠解】

本条论述痰饮上逆的证治。水饮积于下焦，其人小便不利，则水无去路，反逆而上行。若水气相搏，始于脐下，则脐下悸动；水气上冲于胃，故呕吐涎沫；水气上冒清阳，故头目眩晕。

治宜五苓散化气利水。方中白术健脾，运化水湿；茯苓健脾利肺，渗利水湿，桂枝温通阳气，以化水湿；猪苓、泽泻利膀胱之气，引水邪下出。

【选注】

《金匱要略心典》：“瘦人不应有水，而脐下悸，则水动于下矣；

吐涎沫则水逆于中矣；甚而颠眩，则水且犯于上矣。形体虽瘦，而病实为水，乃病机之变也。颠眩即头眩。苓、术、猪、泽甘淡渗泄，使肠间之水从小便出。用桂者，下焦水气，非阳不化也。曰多服暖水汗出者，盖欲使表里分消其水，非挟有表邪而欲两解之谓。”

附方

《外台》茯苓饮

治心胸中有停痰宿水，自吐出水后，心胸间虚，气满不能食，消痰气，令能食。

茯苓 人参 白术各三两 枳实二两 橘皮二两半 生姜四两

上六味，水六升，煮取一升八合，分温三服，如人行八九里进之。

【词解】

宿水：指素有水邪。

【诠解】

本方示痰饮有治本之法。胃气与水邪相搏，胃气拒水于外，故自吐水液。水邪虽去，而心胸间虚弱，不能行气化水，故气满不能食。本证治法，必须补脾消饮，攻补兼施。若不消痰气、令能食同时治疗，则旧饮去而新饮又聚，呕吐又发，循环往复，病久不愈。

治以茯苓饮，健脾益胃，行水化饮。方中人参、白术温补脾胃，令人能食；茯苓、生姜温通化饮，淡渗利湿，可消痰气；陈皮、枳实行气，运化水湿，使水液不停不聚，则痰饮可愈。

【选注】

《金匱要略编注》：“脾虚不与胃行津液，水蓄为饮，贮于胸膈之间，满而上溢，故自吐出水后，邪去正虚，虚气上逆，满而不能食也。所以参、术大健脾气，使新饮不聚；姜、橘、枳实以驱胃家未尽之饮，曰消痰气，令能食耳。”

32.咳家其脉弦，为有水，十枣汤主之方见上。

【诠解】

本条论述痰饮侵肺的证治。痰饮形成之后，若水停膈间，上犯入

肺，故经常咳嗽短气，脉来端直以长如张弓之弦，乃饮邪凝结之候。

治以十枣汤，攻逐水饮，饮去则咳嗽自愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉弦为水，咳而脉弦，知为水饮渍入肺也，十枣汤逐水气自大小便去，水去则肺宁而咳愈。”

33.夫有支饮家，咳烦，胸中痛者，不卒死，至一百日或一岁，宜十枣汤方见上。

【词解】

不卒死：虽不能马上死亡。

【诠解】

本条论述支饮久咳的证治。由于支饮久留膈上，饮邪结实，胸阳被郁，故胸中疼痛，心烦。支饮渍入肺中，故久咳不已。

久病支饮，阳气痹于胸，饮邪塞于肺，心肺俱病，若不卒死，可延至百日或一年。此证要用十枣汤以拔饮邪之根，如不用十枣汤则病不能去，终无愈期，而预后不良。

【选注】

《医门法律》：“五饮之中，独膈上支饮最为咳嗽根底，外邪入而合之固咳，即无外邪而支饮渍入肺中，自令人咳嗽不已，况支饮又蓄膈上，其下焦之气逆冲而上者，尤易上下合邪也。以支饮之故，而令外邪可内，下邪可上，不去支饮，其咳终无宁宇矣。去支饮用十枣汤，不嫌其峻，岂但受病之初，即病蓄已久，亦不能舍此别求良法。其曰咳家其脉弦为有水，十枣汤主之，正谓弦急之脉必以治饮为急也。其曰夫有支饮家咳烦，胸中痛，不卒死，至一百日或一岁，宜十枣汤，此则可以死而不死者，仍不外是方，去其支饮，不几令人骇且疑乎？凡人胸膈，孰无支饮，其害何以若此之大，去其害何必若此之力，盖膈上为阳气所治，心肺所居，支饮横据其中，动肺则咳，动心则烦，搏击阳气则痛，迫处其中，荣卫不行，神魂无依，则卒死耳。至一百日或一年而不死，阳气未散，神魂未离，可知惟急去其邪，则可安其正，所以不嫌于峻攻也。扫除阴浊，俾清明在躬，较悠悠姑待其死，何得何失也。”

34.久咳数岁，其脉弱者可治，实大数者死，其脉虚者必苦冒，其人本有支饮在胸中故也，治属饮家。

【诠解】

本条论述支饮久咳的预后。由于脾肺虚弱，津液化为痰饮，支饮停于胸中，肺气不利，故久咳数岁，缠绵不愈。病久正衰，故脉来虚弱。因顺合病情为可治；若饮邪盛而正气不支，脉来实大数者，则为脉证不顺，故其预后不良。若饮证脉虚，为阳虚有饮，头必苦眩。“其人本有支饮在胸中故也”为自注句，以说明眩冒之病是支饮，治属饮家而以苓桂术甘汤之法意在言外。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“久咳岁数，饮之留伏也久矣，证之成患也深矣。诊之脉弱者，久病正虚，是其常也，久病而邪亦衰，是其幸也，可以于补正气中寓逐水饮之法治之，徐徐可收功也，故曰可治。若夫诊其脉而实而大而数，则正虚而邪方盛，欲补其正，有妨于邪，欲攻其邪，有害于正，可决其死也；然此亦为治之不如法者言耳。苟能遵奉仲景以扶阳益气为本，以温中散寒，清热散邪为斟酌，以导水于二便，宣水于发汗为权宜，何遽致于必死乎？再为谛脉虚者之证必苦冒，脉虚则气弱，气弱而水湿混杂于中，清阳之气必不能升，如物掩覆之，所以苦冒，其人本有支饮在胸中之故显然矣。仲景又明此治不必问之冒家也，还属之饮家，饮消而冒自除矣。”

35.咳逆倚息，不得卧，小青龙汤主之方见上。

【诠解】

本条论述支饮咳嗽的证治。寒饮内伏于胸膈，又因风寒外束，卫气闭塞，内饮外寒，壅塞肺气，故咳嗽，痰多白沫，气逆倚息而不得卧。

治以小青龙汤发散风寒，温中化饮，利痰降逆。

【选注】

《金匱要略编注》：“此表里合邪之治也。肺主声，变动为咳，胸中素积支饮，招邪内入，壅逆肺气，则咳逆倚息不得卧，是形容喘逆不能撑持，体躯难舒，呼吸之状也。故用小青龙汤之麻、桂、甘草开发腠理，以驱外邪从表而出；半夏、细辛温散内伏之风寒，而逐痰饮下行；干姜温肺行阳而散里寒；五味、白芍以收肺气之逆，使表风内饮，一剂而解，此乃寒风挟饮咳嗽之主方。”

36.青龙汤下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难，时复冒者，与茯苓桂枝五味甘草汤，治其气冲。

茯苓桂枝五味甘草汤方

茯苓四两 桂枝四两，去皮 甘草炙，三两 五味子半升
上四味，以水八升，煮取三升，去滓，分温三服。

【词解】

下已：是已服下小青龙汤。

多唾：吐出很多黏稠痰浊。

面翕热如醉状：是指面红而热，如醉酒之状。

下流阴股：是指虚火冲气下流到两腿的内侧。

【诠解】

本条是论述服小青龙汤后引动冲气的变证和救治。病人膈上有支饮，而肾气素虚，故寸脉沉，尺脉微。服小青龙汤后，饮气稍平，但辛温发散之品损伤阴液，扰动阳气，虚阳上越，随冲任之脉上冲胸咽，故气从少腹上冲胸咽，而口中干燥。阳虚不化，痰浊内生，故多唾稠痰。下元本虚又因发散而上浮，故其面翕热如醉状。冲气上及而复下流阴股，膀胱水液无气以化，故小便难。阳气虚弱，不能温暖四肢，故手足厥逆，麻木如痹。冲气往返，扰动痰饮，痰饮阻碍升清降浊，故时复眩晕。

治以桂苓五味甘草汤，扶阳敛冲以固肾气。方中桂枝扶心肾之阳，平冲降逆；茯苓化湿利水，偕桂枝可平冲逆之气；甘草补脾，配桂枝以补心阳之虚；五味子收敛冲气，潜阳于下。

【选注】

《金匱要略发微》：“阳气张于上，则冲气动于下。小青龙汤发其阳气太甚，则口多浊唾而燥。寸脉沉为有水，尺脉微而阳虚。手足厥逆者，中阳痹也。气从小腹上冲胸咽者，以麻黄、细辛之开泄太甚，少阴水气，被吸而上僭也。中阳既痹，故手足不仁。虚阳上浮，故其面翕热如醉状，且浮阳之上冒者，复下流阴股而吸其水道，致小便不利。阳不归根，故时上冒巅顶，方用苓桂五味甘草汤。”

《金匱要略心典》：“茯苓、桂枝能抑冲气使之下行，然逆气非敛不降，故以五味之酸敛其气，土厚则阴火自伏，故以甘草之甘补其中也。”

37.冲气即低，而反更咳，胸满者，用桂苓五味甘草汤，去桂加干

姜、细辛，以治其咳满。

苓甘五味姜辛汤方

茯苓四两 甘草 干姜 细辛各三两 五味半升

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三。

【诠解】

本条论述冲气平后，咳饮又作的治法。服桂苓五味甘草汤后，冲气已止，但膈上支饮又聚，壅闭肺气，故胸满，咳嗽又作。

治以苓甘五味姜辛汤，温肺化饮，敛气止咳。于苓桂方中加干姜上温肺寒，运化津液，断其生痰之源；细辛温散寒饮之结，五味子收敛肺气；又有茯苓利水消饮；桂枝通阳降冲，温化胸肺水寒之邪。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“冲气即低，是阴抑而降矣；然降而不即降，反更咳胸满者，有支饮在胸膈留伏，为阴邪冲气之东道，相与结聚肆害，不肯遽降。心从阳也，法用桂苓五味甘草汤去桂枝之辛而升举，加干姜、细辛之辛而开散，则胸膈之阳大振，而饮邪自不能存，况敢窝隐阴寒上冲之败类乎？虽云以治其咳满，而支饮之邪，亦可殒衰矣。”

《金匱要略心典》：“服前汤已，冲气即低，而反更咳胸满者，下焦冲逆之气即伏，而肺中伏匿之寒饮续出也，故去桂枝之辛而导气，加干姜、细辛之辛而入肺者，合茯苓、五味、甘草消饮驱寒，以泄满止咳也。”

38.咳满即止，而更复渴，冲气复发者，以细辛、干姜为热药也；服之当遂渴，而渴反止者，为支饮也；支饮者，法当冒，冒者必呕，呕者复内半夏，以去其水。

桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤方

茯苓四两 甘草 细辛 干姜各二两 五味子 半夏各半升

上六味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三。

【诠解】

本条在上条的基础上，论述冲气与饮逆的鉴别及饮逆的辨证论治。服苓甘五味姜辛汤后，可能有两种病情，一为支饮减轻，咳嗽，胸满已止。但细辛、干姜温散之品，而能下扰虚阳，虚火随冲任上冲至胸咽，上损津液，故口燥而渴。治以桂苓五味甘草汤，摄纳虚阳，平冲降逆。另一种病情为支饮上逆，反不渴。由于肺脾气虚，形成水饮，支饮留于胸膈，饮邪上乘清阳之位，故冒。饮邪犯胃，故呕吐清水痰涎。支饮不得降泄，逆冲于上，故冒者必呕。治以苓甘五味姜辛汤加半夏，温化寒饮，温散水气，行气降逆，饮逆之证可愈。

【选注】

《金匱要略论注》：“寒得热而消，故咳满即止；然热则津耗，津耗则渴；热伤元气，元气伤而阴乃侮阳，故冲气复发。故曰以细辛、干姜为热药也，因而津耗胃干，当遂渴。遂者，不止也，今不应止而止，故曰反，明是素有支饮，故火不胜水。但支饮必有的据，故曰支饮者法当冒，冒者必呕，呕者有水故也，故复纳半夏以去之。同是冲气，而此不用桂枝者，盖冒而呕，则重驱饮，以半夏为主，桂枝非所急也。”

39.水去呕止，其人形肿者，加杏仁主之；其证应内麻黄，以其人遂痹，故不内之。若逆而内之者，必厥。所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。

苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤方

茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升 杏仁半升，去皮尖

上七味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服半升，日三。

【诠解】

本条是承上条，论水去呕止，其人形肿的治法。服苓甘五味姜辛汤加半夏以后，胃中饮邪得以降泄，故呕吐清水痰涎，眩冒等证已除。由于膈上支饮未除，肺失通调之常，经络血脉涩滞不畅，气滞水停，水饮溢于体表，故其人形肿。治以苓甘五味姜辛汤加半夏、杏仁。于前方中加杏仁一味，开降肺气，饮散水下，肺气疏通，气行水行，则肿可去。本方为散寒化饮，温中利肺之剂。

肺失通调之常，饮邪溢于体表，用麻黄宣肺利气，发汗行水，符合

道理，但不符合病情。因为麻黄能发越阳气，可以引起四肢厥冷，又可引起冲气上逆等，故以不用为是。

【选注】

《金匱要略论注》：“形肿，谓身肿也。肺气已虚，不能遍布，则滞而肿，故以杏仁利之，气不滞则肿自消也。其证应内麻黄者，《水气篇》云：无水虚肿者谓之水气，发其汗则自己，发汗宜麻黄也。以其人遂痹，即前手足痹也，咳不应痹而痹，故曰逆，逆而内之，谓误用麻黄，则阴阳俱虚而厥。”

40.若面热如醉，此为胃热，上冲熏其面，加大黄以利之。

苓甘五味加姜辛半杏大黄汤方

茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升 杏仁半升 大黄三两

上八味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服半升，日三。

【诠解】

本条承上条论述痰饮挟胃热上冲于面的证治。服苓甘五味姜辛汤加半夏、杏仁等方，温化水饮，通调水道，水饮能去。若温化水饮，水气不行，湿郁生热，积于胃肠，故有胃热亢盛，热气熏蒸，面红而热，如醉酒状。

治以苓甘五味姜辛汤加半夏、杏仁、大黄。于前方中又加一味大黄，泻胃肠实热，引热下行，涤荡胃肠中的湿热饮邪，从大便而下，故曰：加大黄以利之。

【选注】

《金匱要略论注》：“面属阳明，胃气盛，则面热如醉，是胃气之热上熏之也；既不因酒而如醉，其热势不可当，故加大黄以利之，虽有姜辛之热，各自为功，而无妨矣。”

前既云：以干姜、细辛为热药故也，本方只加半夏，不去姜辛，及形肿，又不去姜辛；及面热，又不去姜辛，何也？盖支饮久咳之人，胸中之宗气久为水寒所触，故极易咳满；逮咳满而藉姜辛以泄满止咳，则姜辛自未可少，谓饮气未即去，则肺之寒侵，刻刻须防之也。至面热如醉，与首条翕然如醉不同，前因冲气，病发在下，此不过肺气不利，乃

滞外而形肿，滞内而胃热，故但以杏仁利其胸中之气，复以大黄利其胃中之热耳。”

41.先渴后呕，为水停心下，此属饮家，小半夏茯苓汤主之方见上。

【诠解】

本条论述痰饮呕吐的证治。由于脾虚不能运化，肺虚不能通调水道，水饮停于中，津液不能敷布于上，所以口渴饮水。饮后水停于胃，水气上逆，则呕吐清水痰涎。

治宜小半夏茯苓汤，温化水饮，降逆止呕。方中生姜温胃散饮，输布津液；半夏涤痰降逆止呕；茯苓利水行饮。三药共成温和之法，使旧饮能去，新饮不生，痰饮可愈。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“先渴后呕，则水逆也，水停心下，阻隔正气不升，则正津不上于胸咽，故渴也。渴必饮水，水得水而愈滋其冲逆，所以先渴而后必呕也。此属饮家，当治其饮不可治其渴也。治饮则用辛燥，治渴必用寒润，可不明其属于何家而妄理乎？主之以小半夏加茯苓汤，无非渗水开格，温中散寒为治也。”

结语

本篇论述痰饮的病因、病机、症状及治法。痰饮的成因，由于脾阳虚不能运化，肺气虚不能通调，肾阳虚不能温化等原因。治疗原则是当以温药和之为法。

痰饮的辨证，主要分四种类型：痰饮、悬饮、溢饮、支饮。若饮邪阻于脾肺，而胸胁支满，目眩者，可用苓桂术甘汤补心健脾，利肺行水；若微饮不去，短气而心悸者，亦可用苓桂术甘汤；下肢寒冷，小便不利，可用肾气丸温养肾气，俾气化一行，则微饮可去。若痰饮成实，留而不行，心下坚满者，或悬饮结于胁下者，可用甘遂半夏汤和十枣汤攻逐水饮。若溢饮溢于肌表，身体疼重，有发热心烦等，可用大青龙汤，发散水气，清除郁热。有寒饮咳喘者，可用小青龙汤，发散水气，温中化饮。

支饮在胸膈，若支流旁出，拒于心下，支撑上逆，病变复杂。有膈

间支饮，咳喘胸满，心下痞坚者，可用木防己汤；有心下支饮，其人苦冒眩者，可用泽泻汤；有支饮胸腹胀满者，可用厚朴大黄汤；有支饮壅肺不得息者，可用葶苈大枣泻肺汤；有支饮溢于胃，呕吐清水痰涎者，可用小半夏汤；有支饮入肺，胸阳被郁，咳嗽心烦，胸中痛，有卒死之险者，急用十枣汤攻逐水饮。

痰饮邪气，有走于肠间、膈间、脐下、胃中等部位，可选用己椒苈黄丸、小半夏加茯苓汤、五苓散，以去其水饮为主。

支饮在膈上，留伏已久，病情较为复杂，在治法上，具体论述了观其脉证，随证应变的治疗原则。如用小青龙汤内温外散，若引动冲气，则有桂苓五味甘草汤之治；又有冲气即低，肺饮复动的苓甘五味姜辛汤，为化饮敛阳之法；以及饮气上逆，昏冒呕吐的苓甘五味姜辛汤加半夏，降逆止呕之法；有水去呕止，气滞水停，其人形肿者，可用苓甘五味姜辛汤加半夏、杏仁，利肺行三焦之治；也有胃中热气上熏其面，面红如醉状的苓甘五味加姜辛半杏大黄汤，引胃热下行。

总之，仲景设法御变，因证用药，不拘一格，能于其中，举一反三，心领神会，则庶几近之矣。

消渴小便不利淋病脉证并治第十三

概说

本篇是论述消渴、小便不利和淋病的辨证论治。篇中共有条文十三条，载方六首。其中第一、二条阐述了消渴的病机、脉证。第三、六、十二条是论消渴的证治和方药。第四、五条、十三条是论小便不利兼有消渴的证治和方药。第十、十二条则论小便不利的证治和方药。第七、八、九条阐述了淋病的脉证和治疗原则。由于消渴、小便不利和淋病的病变部位都和肾与膀胱有关，主要症状是消渴和小便不利方面的变化，故合为一篇论述。

消渴病，指其人口渴能饮，饮水能消，即水入不足以制火，而反为火所消的病变，然亦有由于津液内凝，变而为水，水蓄于下，则小便亦可出现消渴的证情。两者对比，以加强辨证思想。消渴可分为上、中、下三种。上消则在于肺，中消则在于胃，下消则在于肾。上消在肺，则口干舌燥，而渴欲饮水；中消在胃，热盛而燥，则消谷善饥而多食为突出；下消在肾，气虚寒冷，不能蒸水化气，则有多饮多尿之变。

小便不利，是一个证候，它可以出现于很多的疾病之中。举例而言，如肾阳虚的气化不行；或少腹有瘀血，郁而化热，或脾肾两虚，气化不利等原因，皆能引起小便的不利。

淋病是以小便淋沥涩痛为主证，多与下焦蓄热有关。

1.厥阴之为病，消渴，气上冲心，心中疼热，饥而不欲食，食即吐蛔，下之不肯止。

【诠释】

本条是论述消渴病的辨证。厥阴肝为风木之脏，中见少阳相火，为阴中之阳脏，若风郁火燔之为病，脏燥求救于水，则为消渴。火生于木，肝气通于心，故气上冲心，心中疼热。胃受木克而求救于食，则知饥；然胃虚未复，故胃腑虚热，饥而不欲食。如强与食则随肝气上冲，故食后即吐，有蛔则随吐而出，此乃厥阴消渴证外兼之证。此证与“二

阳结谓之消”病机不同，故彼则可下，此则禁下，若误下厥阴，则徒伤脾胃，而下利不肯止。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“肾中之水竭则命门火发，命门火发必缘木而升，所以消渴一证既责之肾水，再责之肾火，终责之肝木，阙一不可与言消渴之由来矣。其证必气上冲心，心中疼热，一皆水不足而火有余之象也。于是其人善饥而不食，此何以故？以胃虚而膈热，热必入于胃，胃中虬虫因热而不能安伏于胃之下脘，乃乘热而浮游于胃之上脘，胃热故善饥；虬在上脘故不欲食。食入而虬在食下，则相安；食入而虬反在食上，则吐虬，此胃热之所致也。肾水枯竭之人，胃气不足久矣，徒以热入胃中耗其精而扰其虬，而初无实邪可以攻伐也。设误下之，下利自不可止矣。此非滋其肾火，养其肝木，充实其阳气，宣散其邪热，则消渴之证未易言除也。于此误下固非矣，即妄用寒凉以为能滋阴止渴，不知阳火以滋阴而渴止，阴火以滋阴而渴证且更他变矣。故主治者，壮水之本法之要也，益火之源尤法之要也。阳能生阴，阳足而阴自足，是又本治中之先务也。”

2.寸口脉浮而迟，浮即为虚，迟即为劳，虚则卫气不足，劳则荣气竭。趺阳脉浮而数，浮即为气，数即消谷而大坚一作紧，气盛则溲数，溲数即坚，坚数相搏，即为消渴。

【诠解】

本条论述消渴病的病机构成。消渴病的原因很多，本条的消渴由于营虚的燥热和胃气的热盛引起津液不滋，形成消渴的病理机制。

营血虚竭，则不能充盈血脉；血少则不能滋灌全身，故脉来迟涩，反映营虚的一方面。营血虚竭，则燥热内生，进而更耗阴伤气，而使卫气不足。阳虚气浮，故脉浮而无力。阴血虚少，阳气浮动，燥热内生，势必形成消渴病变。

胃气热盛，则消谷善饥，脉浮而数。胃热伤阴，不润肠道，故大便坚硬。胃热伤津，燥热炽盛于肺，故胸膈燥烦，而口干多饮。脾不能运化水湿，敷布津液，反被胃之燥热所逼，偏渗于下，故而小便则频数；小便频数，则大便必坚，即为消渴之病。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“浮者，浮取大而无力也；迟者，沉取涩而不滑也。寸口主肺属气，浮弱之诊，中气不足，而卫气何有于足乎。寸口又主膻中属血，涩迟之诊心血不足，而荣气何得不竭乎。一言虚，

阳虚气病也；一言劳，阴虚血病也。合言之，则虚劳内热，消渴之证甚明也，此其一诊也。再诊趺阳，阳明胃气也。脉浮而数，浮者气散而不收也；数者热盛而不熄也。气散不收则流注多而漫无检制；热盛不熄则谷虽消而津液日亡。所以气盛而小便常苦多，故溲数。溲数而津液日益耗，大便愈坚。以大便坚与小便数相搏，而正津亏竭，邪热炽盛，胸膈燥烦，口舌干裂求救于水，水入气不足运，随波逐流直趋而下，饮多溲多，无补于渴。此消渴之热发于肾，冲于肝，而归结于胃，受害于肺也。”

3.男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，肾气丸主之方见妇人杂病中。

【诠解】

本条论述下消的证治。由于肾阴虚少，肾阳衰弱，不能蒸腾津液以上润，又不能摄水，以固州都，故多饮多尿，饮一溲一。治以肾气丸，温阳化气，滋阴生津。方中干地黄、山药、山茱萸、泽泻、丹皮、茯苓滋阴润燥，补益真阴；附子、桂枝温暖肾阳，蒸水化气，施化四布，则津液升而小便缩，以上诸证，自可消除。

【选注】

《金匱要略直解》：“肾中之气犹水中之火，地中之阳，蒸其精微之气达于上焦，则云升而雨降，上焦得以如雾露之溉，肺金滋润得以水精四布，五经并行，斯无消渴之患。今其人也摄养失宜，肾本衰竭，龙雷之火不安于下，但炎于上而刑肺金，肺热叶焦则消渴引饮。其饮入于胃，下无火化直入膀胱，则饮一斗溺亦一斗也，故用桂附辛热，引真火归原；地黄纯阴，壮真水以滋肾，则阳光行于地下，而雾露自降于中天，何消渴之有，此属下消。”

4.脉浮，小便不利，微热消渴者，宜利小便、发汗，五苓散主之。

【诠解】

本条论述太阳膀胱表里皆病，而水蓄于下，津液不化的证治。由于外感风寒，表邪不解，故脉浮，身有微热；太阳之气不利，而使水气不化，则小便不利；津液不能上润，故消渴能饮。

治以五苓散，解表清热，利水化气，方中桂枝疏风解肌，温化水液；茯苓、白术调畅三焦，渗利水湿；猪苓、泽泻清热利水。诸药相合，使表解热除而气化通畅，小便一利，则诸证可愈。

【选注】

《金匱要略方論本義》：“有證亦消渴而因不同者，又不可概以虛勞之目也，如脈浮而小便不利，則非水無制而火衰，火上升而津耗之證矣；其脈亦浮者，必風濕外感之邪也。表外中風脈必浮，內有濕熱，故小便不利，正津為濕邪所格，不能上于胸咽，故消渴，是飲多而不小便，水為內熱所消，非同于虛勞之飲一斗溲一斗，以小便為消也。主之以五苓散，導水清熱滋干，且用桂枝驅邪于表，表里兼治之道，為外感風濕內生邪熱者，治消渴與虛勞之消渴迥然不同也。”

【病案舉例】

鍾某，男，57歲，老中醫。因飽食山豬肉下酒，突然尿閉4天，西醫外科檢查前列腺極度腫大，堵塞膀胱及尿道內口，軟膠導管無法導入，金屬導尿管雖導入而尿仍不出。病者拒絕膀胱造瘻，只得在耻骨聯合上膀胱處抽尿。老人痛苦難忍，于1971年6月轉中醫科治療。此時病者膀胱脹急，疼痛哭吼，面色淡黃，口淡不渴，舌苔薄膩而滑，脈浮。此酒濕傷中，濕熱下流膀胱之證。蓋膀胱因濕熱阻滯，不得氣化而閉塞不通。患者自服中藥數劑，苓萃一派峻利之品，服之仍無效者，以不得氣化之故也。予五苓散重用桂枝，以轉膀胱之氣化，氣化得行小便通矣。

處方：桂枝45克，白朮12克，澤瀉12克，茯苓30克，豬苓15克，車前子15克。入夜服藥，雞鳴小便即通。

十八個月後，舊病復發，二次手術摘除前列腺後小便仍點滴不通，予補中益氣湯合五苓散，小便方行。

（摘自《上海中醫藥雜誌》1982,4:17）

5.渴欲飲水，水入則吐者，名曰水逆，五苓散主之方見上。

【詮解】

本條在上一條基礎上而論水邪上逆形成嘔吐的，仍以五苓散為主。

【選注】

《金匱要略心典》：“熱渴飲水，熱已消而水不行，則逆而成嘔，乃消渴之變證。曰水逆者，明非消渴而為水逆也。故亦宜五苓散去其停水。”

【病案舉例】

患者吉某，男，36歲。發熱，繼以腹瀉，日夜10余次之多，伴有腹鳴，納少欲嘔，旋忽小便不暢，漸至少腹脹。住本院觀察室一晝夜，經治療腹瀉漸止，而少腹脹，尿少依然，煩渴引飲，水入即吐，體溫

38.1℃，脉浮弦滑，舌薄苔白滞。脉证结合，属太阳腑病蓄水证无疑，五苓散主之。

方用：炒白术9克，云茯苓12克，猪苓、泽泻各9克，川桂枝5克，法半夏9克，陈皮7克，生知、柏各6克，藿、佩梗各6克，鲜荷叶1角。二剂之后，越一日再诊时，患者主诉：药后佳良，小溲畅通，小腹胀已好，服头煎药即有效，服二煎药病若失。苔脉均有起色，体温已趋正常，原方加进二剂以资巩固疗效。

（摘自《江苏中医杂志》1980,5:16）

6.渴欲饮水不止者，文蛤散主之。

文蛤散方

文蛤五两

上一味，杵为散，以沸汤五合，和服方寸匕。

【诠解】

本条是论述阴虚燥热消渴的辨证论治。由于肾阴虚少，虚火上炎，移热于肺，肺燥阴伤，故饮水不止。虽然渴饮不止，但犹不能以制燥渴，故其人饮水不止。治以文蛤散，益水行水以治消渴。文蛤咸凉，有润下退火，益水行水之功，故治上消的渴饮。

此条接五苓散证之后，亦行水清热、调治津液之法，此条与《伤寒论》的文蛤散证，可以对比发明。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“尝考《本草》文蛤、海蛤，治浮肿，利膀胱，下小便，则知内外之水，皆可用之。其味咸冷，咸冷本于水，则可益水，其性润下，润下则可行水，合咸冷润下则足可退火，治热证之渴饮不止，由肾水衰少，不能制盛火之炎燥而渴，今益水治火，一味两得之。《内经》曰：心移热于肺，传为膈消者，尤宜以一味切于入心也。”

7.淋之为病，小便如粟状，小腹弦急，痛引脐中。

【诠解】

本条论述淋病的辨证。淋之为病，小便短而频数，尿出如粟米状。此乃湿热之邪煎熬膀胱津液，结成固体物质，小者如沙如米，阻塞尿

道，使尿液通行不畅，故尿灼热，疼痛，淋漓不快，小腹拘急，而痛引脐中。

【选注】

《金匱要略心典》：“淋病有数证，云小便有粟状者，即后世所谓石淋是也。乃膀胱为火热燔灼，水液结为滓质，犹海水煎熬而成咸硷也。小腹弦急，痛引脐中者，病在肾与膀胱之也。”

8. 趺阳脉数，胃中有热，即消谷引食，大便必坚，小便即数。

【论解】

本条论述胃热下注转成淋病的病机。由于胃中有热，故消谷善饥，趺阳脉数。胃热伤津，不润肠道，故大便必坚。胃热伤津，津液不布，膀胱水少而热，故尿黄量少而频数，则形成热淋。

【选注】

《金匱要略浅注》：“淋病为下焦之热，而下焦本于中焦。趺阳者胃也；趺阳脉数，胃中有热，即消谷引饮，大便必坚，小便则数，数而无度，茎中不痛，是热气燔灼，消渴之渐也。频数而短，茎中作痛，是热气下注，淋病之根也。此言淋病由于胃热下注，与消渴异流而同源也。”

9. 淋家不可发汗，发汗则必便血。

【论解】

本条是论述淋病禁用汗法。淋病多为肾阴虚而膀胱热，津液自是不足，虽有表证亦不可发汗。若发阴虚有热之汗，更夺其津液，则使阳热之邪更重，若热甚迫血妄行，则有尿血等证发生。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“淋者，膀胱与肾病热也。肾属于阴，阴血已不足，若更发汗，则动其营，营动则血泄矣。”

10. 小便不利者，有水气，其人苦渴，栝楼瞿麦丸主之。

栝楼瞿麦丸方

栝楼根二两 茯苓 薯蓣各三两 附子一枚，炮 瞿麦一两

上五味，末之，炼蜜丸梧子大，饮服三丸，日三服，不知，增至七

八丸，以小便利，腹中温为知。

【诠解】

本条论述气化不行，小便不利的证治。由于肾阳不足，气化无权，水气不行，故小便不利。气化不行，小便不利，则生寒，故腹中冷。肾阳虚弱，不能蒸化，津不上承，故其人苦渴。

本证为下寒上燥之证，单纯温阳，则上焦热燥更甚，单纯滋阴润燥，则又碍于肾阳之虚，故以栝楼瞿麦丸，清上焦之热，补中焦之虚，妙在加附子一枚，振作肾气，以为诸药之帅。方后注云“腹中温”三字，为治疗之眼目，此方亦肾气丸之变化。

【选注】

《金匱要略浅注》：“膀胱之所以能出者，气化也；气之所以化者，不在膀胱而在肾。故清上焦之热，补中焦之虚，行下焦之水，各药中加附子一味，振作肾气，以为诸药之先锋。方后自注腹中温三字，为大眼目，即肾气丸之变方也。”

【病案举例】

刘某，女，40岁，重庆建设银行职工。

1964年12月20日初诊：水肿，小便不利一年许，口渴增剧，水肿加重两月左右。

现症：全身水肿，口渴引饮（工作和就诊时，自带大型瓷缸一个，每天要喝24缸子水，至少约24磅），腰冷腿软，精神萎靡不振，纳差，每餐约一两米饭，小便不利，短小而淡黄，尿无热感，大便2~3天一次，不结燥，面色浮白，唇淡，舌质淡，无苔乏津，脉沉细。重庆医生诊断为慢性肾小球肾炎，经服中西药，治疗一年左右，疗效不显，近两月来，病情加剧，其人苦于渴饮，水肿愈增，小便淡黄短少，于是来重庆市第二中医院就诊。当时诊断为水肿，此系肾阴不足，气化紊乱，形成上燥下寒之渴、肿、小便不利证，拟以润燥生津、温阳利水主治，方用栝楼瞿麦汤（丸剂改用汤剂），加鹿胶以填补精血。

方药：栝楼根30克，怀山药30克，茯苓15克，瞿麦15克，制附子15克（另包，先煎2小时），鹿胶12克（另包蒸化兑服）。

1964年12月23日二诊：上方服2剂，口渴大减，饮水量减少一半，每天喝水约12磅，水肿亦大减，小便量增多而畅利，饮食增加，每餐吃2两，其余舌脉同上。效不更方，将原方再进2剂。

1964年12月26日三诊：上方又服2剂，口渴更减，饮水量每天约4

磅，小便畅利，水肿基本消失，饮食接近正常，每天一次，腰冷消失。现腰酸腿软，精神仍疲倦，夜尿3~4次，舌质淡，无苔微润，脉沉细。此肾阳渐复，气化功能逐渐趋向正常之象，而病理稍有变化，在治法原则上不变，拟以温阳（肾阳）利水为主，辅以生津润燥，佐以填补精血，于原方中将栝楼根改用15克，其余药物和剂量不变，嘱进2剂。

1964年12月29日四诊：上方服2剂，渴饮消失，水肿消失，饮食正常，精神比原来大有好转，时而仍感疲乏，尿色淡黄无热感，夜尿2~3次，腰酸腿软，面色接近正常，唇淡红，无苔津润，脉沉细。效不更方，仍宗前法，继服第三诊方，因余回蓉，嘱服2~10剂，以巩固疗效。

（摘自《成都中医学院学报》1980,1:59-60）

11.小便不利，蒲灰散主之，滑石白鱼散、茯苓戎盐汤并主之。

蒲灰散方

蒲灰七分 滑石三分

上二味，杵为散，饮服方寸匕，日三服。

滑石白鱼散方

滑石二分 乱发二分，烧 白鱼二分

上三味，杵为散，饮服半钱匕，日三服。

茯苓戎盐汤方

茯苓半斤 白术二两 戎盐弹丸大一枚

上三味，先将茯苓、白术煎成，入戎盐，再煎，分温三服。

【诠解】

本条论述小便不利的三种辨证论治方法。蒲灰散适用于湿热郁于下焦，少腹瘀血，气郁血瘀，郁热更重，引起尿赤而少，小便不利，尿道疼痛，少腹急疼等证。蒲灰散有化瘀止血，清热利湿之功。方中蒲灰化

瘀止血，凉血消肿；滑石清热利湿，利窍止疼。

滑石白鱼散适用于少腹瘀血，阻碍气血运行，湿郁化热，引起小腹胀痛，小便不利，尿黄赤或有血尿等证。滑石白鱼散有散瘀止血，清热利湿之功。方中血余炭消瘀止血，通利关窍；白鱼理血脉，行水气；滑石清热利湿。

茯苓戎盐汤适用于脾肾两虚，气化不利，湿热聚于下焦，引起的小腹胀满，小便不利，尿后余沥不尽等证。茯苓戎盐汤有温肾健脾，渗利水湿之功。方中茯苓健脾利肺，渗水行湿；戎盐补益肾气，通络利水，除阴水，清湿热；白术补脾制水。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“自三方观之，悉为膀胱血病涩滞，致气不化而小便不利也。蒲黄、滑石者，《本草》谓其利小便，消瘀血。蒲灰治瘀血为君，滑石利窍为佐。乱发、滑石、白鱼者，发乃血之余，能消瘀血，通关便，《本草》治妇人小便不利，又治妇人无故溺血。白鱼去水气，理血脉，可见皆血剂也。茯苓戎盐汤的戎盐，即北海盐。膀胱乃水之海，以气相从，故盐味润下，佐茯苓利小便；然盐亦能走血，白术亦利腰脐间血，故亦治血也。三方亦有轻重，乱发为重，蒲灰次之，戎盐又次之。”

【病案举例】

郑姓，男，32岁。患者5天来，发热，体温38.3℃，口渴思饮，小便不畅，尿色深黄，有时夹有血尿，尿痛，尿频，少腹拘急。脉象滑数，舌苔黄腻。尿常规检查：红细胞（++++），脓细胞少量。病乃湿热下注，膀胱不利，邪在血分，治当清热利尿，佐以通淋化瘀。方拟蒲灰导赤散加味。

处方：蒲黄3克，滑石12克，生地20克，木通5克，竹叶10克，甘草5克，小蓟15克。连服4剂，发热渐退，体温37.3℃，小便比前通畅，血尿已止。尿检：红细胞（+）。湿热渐去，膀胱通利，原方去木通，加藕节，再服3剂，小便清利，邪热退清，病即痊愈。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,7:2）

12.渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之方见中喝中。

【论解】

本条论述热盛伤津消渴病的证治。由于肺胃热盛，热能伤气，亦能伤津，气虚不能化津，津亏无以上承，所以渴欲饮水，口干舌燥。水入能够滋润，但热盛能消，故口干舌燥不解，此即上消之证。

治以白虎加人参汤，清热生津止渴。方中石膏、知母清热降火，清解肺胃大热；甘草、粳米益胃生津；人参补脾肺之气，气足则生津止渴。

【选注】

《医门法律》：“此治火热伤其肺胃，清热救渴之良剂也。故渴消病之在上焦者，必取用之。东垣以治膈消，洁古以治能食而渴者。”

13.脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。

猪苓汤方

猪苓去皮 茯苓 阿胶 滑石 泽泻各一两

上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，内胶烊消，温服七合，日三服。

【论解】

本条论述肺胃阴伤小便不利的辨证论治。由于胃热阴伤，不能润燥，肺热津伤，不能通调水道，水气停留，水热互结，故脉浮发热，渴欲饮水，小便不利。

治以猪苓汤滋阴益血，渗利水湿。方中茯苓健脾生津，渗利水湿；阿胶补阴以生津，猪苓、泽泻、滑石利水清热。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“此节猪苓汤证，是证发于肺经，肺主皮毛，而先见发热，是肺有热也。肺热津不布，故渴欲饮也。外热上渴，肺既受伤，不能通调水道，因而小便不利，是先病肺之虚热也，但当滋肺经之虚热为主，故用阿胶与滑石。”

【病案举例】

某一女性患者，年30岁。发烧，腰痛，尿道灼痛，尿急短赤，脉数，苔黄微腻质红，尿常规化验红细胞较多，乃下焦湿热，伤及阴络，气化失职，宜滋阴清热利湿，佐通阳凉血之品。

处方：猪苓12克，泽泻12克，白术9克，云茯苓15克，桂枝9克，阿胶12克（烊化兑服），滑石12克，甘草梢6克，生地12克，血余炭9克，地肤子9克，芍药9克。

服上方五剂后，烧退，尿道灼热痛消失，腰痛已减，尿常规化验红细胞消失。

（摘自《赵锡武治疗经验》第36页）

结语

本篇论述消渴病的病因病机，有肺胃津伤、胃热及肾虚等方面。在辨证施治上，提出肾虚消渴，用肾气丸温暖肾阳；水湿痰饮内停的消渴，用五苓散温化水湿；阴虚燥热者，用文蛤散益阴制水；肺胃热盛者，用白虎加人参汤清热而补气津以止渴。

小便不利的辨证施治，因气化不行者，用五苓散温化水湿；肺胃热盛，水热互结者，用猪苓汤渗利水湿；上热下寒者，用栝楼瞿麦丸温阳行水，生津润燥；少腹瘀血者，用蒲灰散或滑石白鱼散消瘀利水；脾肾两虚者，用茯苓戎盐汤补虚利水。

淋病的辨证，可分肾阴亏虚火旺和胃热伤津等。以上方剂，可以辨证选用。

水气病脉证并治第十四

概说

本篇是论述水气病和黄汗病的辨证论治。本篇共有条文三十二条，载方九首（其中有方无药一首），附方一首。篇中第一条至第四条、第六条至十二条阐述了水气病的分类、脉证、发病机理等。第十三条至十七条阐述了五脏之水的证候。第十八、二十一条指出水肿病的治疗原则，以及误治后的辨证和治法。第十九、二十条是论血分病引起水肿的脉证、血分病与气分病的鉴别。第二十二、二十三条是论风水的方证。第二十四、二十七条是论皮水的方证。第五、二十五条是论里水的方证。第二十六条则论正水、风水与虚胀的鉴别，以及正水与风水的方证。第二十八、二十九条是论黄汗病的脉证和方药。第三十至三十二条是论气分病的发病机理、脉证、辨证与方药等。

水气病，即水肿病。水气病的病机主要是肺、脾、肾三脏的通调，运化和气化功能失调，而水湿停留，聚为水肿。水气病，是指水不化气，气不化津不行，聚而为肿的病证而言。治疗水气大法有三：即发汗、利水、逐水。也就是《内经》的“开鬼门，洁净府”的治疗原则。水肿病有四种类型：风水、皮水、正水、石水。至于五脏水气，可列入正水、石水之类。

黄汗病的主证是汗液色黄，病机是湿郁在表，湿热交蒸所致。治疗以调和营卫为主。另外，本篇还论述了血分病和气分病，可与水气病鉴别。

1.师曰：病有风水，有皮水，有正水，有石水，有黄汗。风水其脉自浮，外证骨节疼痛，恶风；皮水其脉亦浮，外证胛肿，按之没指，不恶风，其腹如鼓，不渴，当发其汗；正水其脉沉迟，外证自喘；石水其脉自沉，外证腹满不喘；黄汗其脉沉迟，身发热，胸满，四肢头面肿，久不愈，必致痈脓。

【诠解】

本条是论述风水、皮水、正水、石水、黄汗的症状和病机。水气病是水肿证的总称。细分起来，又有风水、皮水、正水、石水和黄汗五类，兹分如下：

风水，是由于风邪侵袭肌表，故脉浮而恶风。风邪使肺气不宣，则不能通调水道，而使水气停滞，留于体表、四肢、关节，故头面浮肿，而骨节疼痛。

皮水，是由于脾阳虚，不能运化水湿，湿邪阻滞中焦，故腹满如鼓状。肺气虚则不能通调，以致水湿停滞皮中，故下肢踝部浮肿，按之没指，水性润下故也。脾阳虽虚而不甚，阳气尚能外达，水湿由里外溢，津液上承，故口不渴，而脉亦浮。虽无恶风等表证，但水湿有外溢之趋势，故因势利导，可发其汗，使水从皮肤排出，则皮水可立消。

正水，是由于脾肾阳虚，不能气化，蒸发水湿之邪，水停于里，故腹满，而脉沉迟。若水气外溢，则作浮肿。水气上逆而作喘。水在下则小便不利。盖水气之邪变动不居，而泛滥成灾，亦勿怪其然。

石水，是由于肾阳虚衰，不能温化水湿，水气结于少腹，故腹满如石，脉沉。水聚于下，未及于肺，故不喘。若水气波及肝区，可见胁下胀痛。

黄汗，是由于脾阳虚，不能运化水湿，水湿内郁，故其脉沉迟。湿郁化热，湿热流于肌肤，故身热，四肢头面肿。湿热入营，邪热郁蒸，汗出色黄，故名“黄汗”。湿热上蒸，肺气不畅，故胸中满闷。若本病日久不愈，湿热外蒸，郁滞不透，腐肉化脓，故可导致痈肿浸淫流脓。

【选注】

《金匱要略心典》“风水，水为风激，因风而病水也。风伤皮毛，而湿流关节，故脉浮恶风而骨节疼痛也。皮水，水行皮中，内合肺气，故其脉亦浮，不兼风，故不恶风也。其腹如鼓，即《内经》**整整**然不坚之意。以其病在皮肤而不及肠脏，故外有胀形，而内无满喘也。水在皮者，宜从汗解，故曰当发其汗。正水，肾脏之水自盛也；石水，水之聚而不行者也。正水乘阳之虚而侵及上焦，故脉沉迟而喘；石水因阴之盛而结于少腹，故脉沉腹满而不喘也。黄汗，汗出沾衣如蘘汁，得之湿热交病，而湿居热外，其盛于上而阳不行，则身热胸满，四肢头面肿，久则侵及于里而营不通，则逆于肉理而为痈脓也。”

《金匱要略直解》：“风水与皮水相类属表，正水与石水相类属里；但风水恶风，皮水不恶风；正水自喘，石水不自喘为异耳。”

2.脉浮而洪，浮则为风，洪则为气。风气相搏，风强则为隐疹，

身体为痒，痒为泄风，久为痂癩；气强则为水，难以俯仰。风气相击，身体洪肿，汗出乃愈，恶风则虚，此为风水；不恶风者，小便通利，上焦有寒，其口多涎，此为黄汗。

【词解】

隐疹：即瘾疹。指风疹块遍及全身而痒痛之证。

泄风：风热外泄于表，瘙痒不止的证名。

痂癩：风热在表，搔痒不止，搔破结痂遍及全身，而如癩状。

洪肿：洪，大水之称，指全身浮肿严重。

【论解】

本条是论述风水的病机，以及风水为病的特点。风水卫气强是由于外感风邪而内有水气，故脉浮而洪。浮为风，故恶风；洪为热盛，故洪则为气。风气相搏，风强伤卫，则为瘾疹，而遍身瘙痒。风热燥血，则瘙痒不止，搔破结痂，遍及全身而形如癩；气强则卫受邪，而表闭气郁，不能行水，故身体洪肿，难以俯仰。本证由于风邪闭郁肌表，内热外蒸，水停为肿。故用发汗解表法，使风热与水皆从皮表排出。

黄汗，为脾虚不运化水湿，湿郁化热，侵入营分，热邪郁蒸而汗出色黄。无表证，故不恶风。下焦无病，故小便通利。肺脾虚，上焦不能敷布津液，故其口多涎。口多涎的病机，可体会为寒邪，又可体会为痰饮。夫肺脾者太阴也，肺脾之气羁绊，而湿邪久留，此黄汗之所由也。

【选注】

《医宗金鉴》：“六脉俱浮而洪，浮则为风，洪则为气。风气相搏之病，若风强于气，相搏为病，则偏于营，故为隐疹，身体为痒，痒者肌虚，为风邪外薄故也。名曰泄风，即今之风燥疮是也。故日久不愈，则成痂癩、疥癬、疔癩之类是也。若气强于风，相搏为病，则偏于卫，故为水气，难以俯仰，即今之支饮喘满不得卧也。若风气两相强击为病，则为风水，故通身浮肿也。以上诸证皆属肌表，故当发汗，汗出乃愈也。风水无汗，当以越婢汤发汗，若汗出恶风则为表阳虚，故加附子也。若不恶风，小便通利，非表阳有寒，乃上焦有寒也。上焦有寒，惟兼病水者，则其人口内必多生涎沫也。”

3.寸口脉沉滑者，中有水气，面目肿大，有热，名曰风水；视人之目窠上微拥，如蚕新卧起状，其颈脉动，时时咳，按其手足上陷而不起者，风水。

【词解】

目窠：即眼睑。

微拥：即微肿。

颈脉：指颈侧人迎动脉。

【诠解】

本条是论述风水的辨证。水气较甚的风水病，是由于肺中有水气，故寸口脉沉；又外感风邪，闭郁肺气，郁而化热，热动水生，脉则流利充实，故脉滑。水热上壅，聚于头面，故发热面目肿大，目窠上微拥如蚕状，或像睡眠后刚起床之状，颈脉跳动。水气阻于肺，故时时咳嗽；水气溢于四肢，故手足肿，按之陷而不起。

本证为水气较甚的风水病，且有郁热，病势发展很快，应及早治疗。

【选注】

《金匱要略直解》：“沉者就下之性，滑者流衍之象，故沉滑者中有水也。面肿曰风，风郁于经则热，故面肘肿大热，名曰风水。《内经》曰：诸有水者，微肿先见于目下也。水者阴也，目下亦阴也，腹者至阴之所居，故水在腹者必使目下肿也。颈脉人迎脉也，水邪上干，则颈脉动，水之本在肾，水之标在肺，故时时咳也。以手按其腹随手而起，此属水胀，如按水囊者，必随手而起。今风水搏于手足跗属肌肉之间，按而散之猝不能聚，故下陷而不起也。”

4.太阳病，脉浮而紧，法当骨节疼痛，反不疼，身体反重而酸，其人不渴，汗出即愈，此为风水。恶寒者，此为极虚，发汗得之。渴而不恶寒者，此为皮水，身肿而冷，状如周痹。胸中窒，不能食，反聚痛，暮躁不得眠，此为黄汗，痛在骨节。咳而喘，不渴者，此为脾胀，其状如肿，发汗即愈。然诸病此者，渴而下利，小便数者，皆不可发汗。

【词解】

太阳病：指足太阳经表受邪。

周痹：病名，痹之一种，其证疼痛，偏于一侧，能上下游走，而左右则不移动为其特点。

脾胀：应作肺胀。

【诠解】

本条是论述风水、皮水、黄汗、肺胀的辨证和治疗原则。风水病是

由于肺气不能通调水道，内有水湿，又外感风寒，风寒闭塞，湿邪在于肌表，故脉浮而紧，身体重而酸，头面体表水肿。寒湿在肌表，未入关节，故骨节反而不疼。寒湿之病，在肺与肌表，脾气尚能输布津液，故其人反不渴。此为风水，用发汗解表法，可去在表之风寒湿邪。发汗之后，损伤阳气，阳气极虚，故恶寒。

皮水病是由于脾阳虚不能运化水湿，水湿阻滞于中，里水外溢，肺气通调无力，水湿留于皮中，而为皮水。脾虚湿停，津液不能上承，故口渴。此类皮水，病在肺脾，故无表证。

黄汗病是由于脾虚不运，水湿郁而化热，湿热上蒸，气机不畅，故胸中窒息，暮躁不得眠。湿热上蒸，郁于营分，欲透不透，故汗出色黄。汗出伤阳，故身冷；湿郁而身肿，聚而不行则痛，而状如周痹。脾气虚弱，故不能食。

肺胀是由于外感寒湿，闭塞肺气，寒水内动，故咳而喘息，口不渴。寒湿闭于肌表，故其形如肿，而骨节疼痛。用发汗解表法，散风寒邪，宣通肺气，则诸证自愈。

以上风水、皮水、黄汗、肺胀证，症状虽有不同，但病机则同，所以都可用解表法治之。如果若见渴而下利，小便频数，则为体内津液已伤。如再用汗法，则津液必然枯竭，故曰：皆不可发汗。

【选注】

《金匱要略心典》：“太阳有寒，则脉紧骨疼；有湿，则脉濡身重；有风，则脉浮体酸。此明辨也。今得伤寒脉而骨节不疼，身体反重而酸，即非伤寒，乃风水外胜也。风水在表而非里，故不渴。风固当汗，水在表者亦宜汗，故曰汗出即愈；然必气盛而实者，汗之乃愈，不然则其表益虚，风水虽解，而恶寒转增矣。故曰恶寒者，此为极虚，发汗得之。若其渴而不恶寒者，则非病风，而独病水，不在皮外，而在皮中，视风水为较深矣。其证身肿而冷，状如周痹。周痹为寒湿痹其阳，皮水为水气淫于肤也。胸中窒，不能食者，寒袭于外，而气窒于中也；反聚痛，暮躁不得眠者，热为寒郁，而寒甚于暮也。寒湿外淫，必流关节，故曰此为黄汗，痛在骨节也。其咳而喘不渴者，水寒伤肺，气攻于表，有如肿病，而实同皮水，故曰发汗则愈。然此诸病，若其人渴而下利，小便数者，则不可以水气当汗而概发之也。仲景叮咛之意，岂非虑人之津气先亡耶。”

5.里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故令病水，假如小便自利，此亡津液，故令渴也，越婢加术汤主之方见中风。

【词解】

里水：水从里积而溢于外。

黄肿：与皮水不同。在皮内，色黄肿胀。

【诠解】

本条是论述脾肺气虚，内有郁热的辨证论治。由于脾胃虚弱，不能运化水湿，水停于里，故脉沉。肺气不宣，不能通调水道，下输膀胱，故小便不利。水湿既不能下行，又不能外达，郁滞化热，泛于肌表，故一身面目黄肿。

治宜越婢加术汤，宣肺健脾，利水清热。方中白术、甘草、生姜、大枣健脾化湿，调和营卫；麻黄宣肺通调水道，以利小便；石膏清泄郁热，以退黄肿。

“越婢加术汤主之”七字，接“故令病水”句下，此为倒装句。假如小便自利，为肺气尚能通调水道，而下输膀胱，汗多则伤液，此亡津液，故令渴也。治宜健脾运化水湿，输布津液为主，不宜再用越婢加术汤发汗，恐亡津液。

【选注】

《金匱要略心典》：“里水，水从里积，与风水不同，故其脉不浮而沉，而盛于内者，必溢于外，故一身面目悉黄肿也。水病，小便当不利，今反自利，则津液消亡，水病已而渴病起矣。越婢加术，是治其水，非治其渴也。以其身面悉肿，故取麻黄之发表；以其肿而且黄，知其湿中有热，故取石膏之清热，与白术之除湿。不然，则渴而小便利者，而顾犯不可发汗之戒耶？或云：此治小便利，黄肿未去者之法，越婢散肌表之水，白术止渴生津也，亦通。”

6. 趺阳脉当伏，今反紧，本自有寒，疝瘕，腹中痛，医反下之，下之即胸满短气。

【词解】

趺阳脉：指足背太冲穴动脉，以候胃气安危。

疝瘕：疝是睾丸痛连少腹，抽引急痛。瘕是腹中包块，或聚或散，没有固定形位。

【诠解】

本条论有兼宿痰而致水气的脉证。趺阳脉本不当伏，若因水气伏而脉亦当伏。今反紧，紧则为寒，此因其人有寒，疝瘕，腹中痛。医不温

其寒，而反下之，阳气重伤，即胸满短气，而水病大作。

【选注】

《金匮要略方论本义》：“趺阳有水邪则当伏，以胃阳为水湿阴寒所固闭，故阳明之脉不出也。今反紧，不惟水盛于里，而且寒甚于中矣。盖其人不止有水气之邪，而更兼平日有积寒痼疾，腹中常常作痛，水邪中又兼寒邪也，医者不识其为阴寒，乃以为水邪可下，虽水下沉而寒邪上逆，故胸满气短矣。”

7.趺阳脉当伏，今反数，本自有热，消谷，小便数，今反不利，此欲作水。

【词解】

欲作：待作，未作之意。

【诠解】

本条论述水气挟热，与上条水气挟寒互相对应。两条应对照分析，以加强辨证思维。趺阳胃脉，本不当伏，今因水气内伏，故脉亦伏。若不伏而反数，为本自有热，热则消谷，而小便数多，此乃热迫津液偏渗，而大便则成燥。若其人小便反不利，则为热不化燥，而下与水结，则为欲作“水气”之变。

【选注】

《金匮要略方论本义》：“此病趺阳脉当伏，今反数，为本自有热。然本自有热，则当消谷，小便数，大便坚，如伤寒胃实之证也。今小便反不利，则知为欲作水与湿热之邪无疑。”

8.寸口脉浮而迟，浮脉则热，迟脉则潜，热潜相搏，名曰沉；趺阳脉浮而数，浮脉即热，数脉即止，热止相搏，名曰伏；沉伏相搏，名曰水；沉则络脉虚，伏则小便难，虚难相搏，水走皮肤，即为水矣。

【词解】

潜：气潜于下。

沉：元气沉而不举。

止：水谷精微停止于中，不能运化。

伏：潜伏不升。

【诠解】

本条是以脉象带病机，而论水气病发生之理。寸口脉浮而迟，浮为阳则主热，迟为阴则主潜。热而潜，则热有内伏之势，而不能发于外，名曰沉；热而止，则热有留滞之象，而不能运行，故曰伏；热留于内而不行，则水气因之而蓄，故曰：“沉伏相搏，名曰水。”热留于内，则气不外行，而络脉虚；热止于中，则阳不化而小便难，以不化之水，而走不行之气，则水走皮肤，而成水肿。此条以潜、沉、伏、止以言水；以浮、数以言热。夫水与热结，而又小便不利，则水肿自可难免。此条为热而感水者张目。

【选注】

《金匱要略论注》：“此段论正水所成之由也。谓人身中健运不息，所以成云行雨施之用，故人之汗，以天地之雨名之，人之气，以天地之疾风名之。故寸口脉主上，犹之天道必下济而光明，故曰阴生于阳；趺阳脉主下，犹之地轴必上出而旋运，故曰卫气起于下焦。今寸口脉浮而迟，浮主热，乃又见迟，迟者元气潜于下也。既见热脉，又见潜脉，是热为虚热，而潜为真潜，故曰热潜相搏名曰沉，言其所下济之元气，沉而不复举也。今趺阳脉浮而数，浮主热，乃又见数，数者卫气止于下也。既见热脉，又见止脉，是于客气为热而真气为止，故曰热止相搏名曰伏，言其宜上出之卫气伏而不能升也。从上而下者，不返而终沉，从下而上者，停止而久伏，则旋运之气几乎熄矣，熄灭阴水乘之，故曰沉伏相搏名曰水，见非止客水也。恐人不明沉伏之义，故又曰络脉者，阴精阳气所往来也。寸口阳气沉而在下，则络脉虚；小便者，水道之所以出也，趺阳真气止而在下，气有余即是火，火热甚，则小便难，于是上不能运其水，下不能出其水，又焉能禁水之胡行而乱走耶，故曰虚难相搏，水走皮肤，即为水矣。水者，即身中之阴气，合水饮而横溢也。沉伏二义，俱于浮脉见之，非真明天地升降阴阳之道者，其能道只字耶。”

9.寸口脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒，水不沾流，走于肠间。少阴脉紧而沉，紧则为痛，沉则为水，小便即难。

【词解】

水不沾流：指水不流溢。

【论解】

本条是论水气的病机。水气病在将成未成之际，其脉在上寸口脉弦而紧。紧为寒，弦则卫气为寒邪所结而不行。卫气不行，则阳气无以腠理，司开关。今藩篱不固，因而恶寒；卫阳不行，则水液不沾，流走于肠间，遂横流于肌肤肢体为肿。此言水病之初成，责在卫阳之虚，以

寸口主卫气也。总在寒从外得，阳气被抑，而生水气之证。若脉得诸沉，沉为水结，当责有水，若其人身肿重，则与脉沉相应，故小便难等，为水已成。此言水病之既成，责在肾阳，以少阴主水，肾阳虚则聚水而成肿也。

【选注】

《金匱要略直解》：“寸口以候表，弦紧为寒，寒则表气不行，不能以卫肌肤，故恶寒；气既不行，则水饮亦不宜，但走入肠间而为水。”

《金匱要略论注》：“此言水气已成，亦或于少阴脉见之也。少阴者，尺脉也。紧而沉，紧属寒，故主痛；沉为阴结，故属水。小便即难，言因肾病水而小便即为之不利，非小便难故成水病也。”

10.脉得诸沉，当责有水，身体肿重，水病脉出者死。

【词解】

脉出：水病应脉沉，如徒然暴出，反映真气离根，脱散于外。

【诠解】

本条是从脉象论述水气病的预后。沉为水脉，沉潜为水之象，主阴经之病，故当责有水，而身体肿重。若水病脉沉而陡然脉出，则脉证相反，为根气已散，故预后不良。

【选注】

《金匱要略心典》：“水为阴，阴盛故令脉沉。又水行皮肤，营卫被遏，亦令脉沉。若水病而脉出，则真气反出邪水之上，根本脱离，而病气独胜，故死。出与浮迥异，浮者盛于上而溺于下，出则上有而下绝无也。”

11.夫水病人，目下有卧蚕，面目鲜泽，脉伏，其人消渴，病水腹大，小便不利，其脉沉绝者，有水，可下之。

【词解】

目下有卧蚕：形容下眼胞水肿的形状。

鲜泽：新鲜而光亮。

沉绝：脉沉之甚，而近于绝。

【诠解】

本条是辨水气脉证以及可下之法。病水之人，水盛而土弛，故目下

有形如卧蚕而拥起。水之明亮，故面目鲜泽。沉为水脉，水阻气滞，故沉极则伏。水气为邪，必津液不布，故消渴能饮。水为有形之邪，聚于中则腹大，凡腹大而水无路，故小便必不利。水气如此之重，故脉沉绝。陈修园说：“诊其脉则为无阳，审其势则为有水。故可逐水，水势减轻，再议他法。”

【选注】

《金匱要略心典》：“目下有卧蚕者，目下微肿，如蚕之卧，经所谓水在腹者，必使目下肿也。水气足以润皮肤而壅营卫，故面目鲜泽，且脉伏不起也。消渴者，阳气被郁而生热也。病水，因水而为病也。夫始因水病而生渴，继因消渴而益病水，于是腹大，小便不利，其脉沉绝，水气瘀壅而不行，脉道被遏而不出，其势亦太甚矣，故必下其水，以通其脉。”

12.问曰：病下利后，渴饮水，小便不利，腹满因肿者，何也？答曰：此法当病水，若小便自利及汗出者，自当愈。

【论解】

本条是论述下利后渴饮水而有两种转机。病因下利后，而渴欲饮，若因津少者，饮水后，阴阳自和必自愈。若小便不利，则水有入而无出，积于腹中，而为腹满。腹既满矣，则水气横流，因而水肿。究其然者，以下利后而脾气伤，气伤则水不行，又因饮水过多，而无路可消，则势必然矣。若其人小便自利，及汗出者，则三焦表里通达，则水何从而生。

【选注】

《金匱要略心典》：“下利后阴亡无液，故渴欲饮水。而土虚无气，不能制水，则又小便不利，腹满因肿，知其将聚水为病矣。若小便利则从下通，汗出则从外泄，水虽聚而旋行，故病当愈。然其所以汗与利者，气内复而机自行也，岂辛散淡渗所能强责之哉。”

13.心水者，其身重而少气，不得卧，烦而躁，其人阴肿。

【论解】

以下诸条论述五脏水气为病，本条是论心水的辨证。由于寒水内停，水气上凌，因郁心阳，心火郁于上，故烦躁。心火耗伤心气，心气不足，寒湿有余，故身重短气，不得卧。寒水停于下焦，溢于肌表，心火不能下交于肾，水湿不去，故阴肿。

【选注】

《金匱要略心典》：“心阳脏也，而水困之，其阳则弱，故身重而少气也。阴肿者，水气随心气下交于肾也。”

14.肝水者，其腹大不能自转侧，胁下腹痛，时时津液微生，小便续通。

【词解】

时时津液微生：口中常常生出一点津液。

小便续通：小便有时不利，有时续通。

【诠解】

本条是论述肝水的辨证。由于寒水内停，水侵肝络，气机被阻，故胁下腹痛。肝之疏泄功能失常，肝气时而上冲，时而下降，水液随肝气上升，则时时津液微生；水液随肝气下降，则小便续通。肝病伤脾，不能运化水湿，所以腹部胀大。

【选注】

《金匱要略心典》：“肝病喜归脾，脾受肝之水而不行，则腹大不能转侧也。肝之腑在胁，而气连少腹，故胁下腹痛也。时时津液微生，小便续通者，肝喜冲逆而主疏泄，水液随之而上下也。”

15.肺水者，其身肿，小便难，时时鸭溇。

【词解】

鸭溇：大便中水粪混杂，有如鸭溇，又称鹜溇。

【诠解】

本条是论述肺水的辨证。由于寒水内停，水迫于肺，肺气不行，不能通调水道，下输膀胱，故小便难。水溢肌表，故其身肿。水走大肠，故大便如鸭溇。

【选注】

《金匱要略论注》：“肺主气，以运于周身，病则正气不布，故身肿。小便必因气化而出，气不化故小便难；肺气病，则不能受脾气之上输，肺脾交困而鸭溇。鸭溇者，如鸭粪之清而不实也。”

16.脾水者，其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少气，小便难。

【诠解】

本条是论述脾水的辨证。由于寒水内停，湿困脾胃，脾失转输之常，不能升清降浊，水湿聚于中，流于四肢，故其腹大，四肢苦重。脾

为湿困，津液不生，气亦不足，故口渴，少气。脾不散精于肺，肺不通水道以行决渎，故小便难。

【选注】

《金匱要略心典》：“脾主腹而气行四肢，脾受水气，则腹大四肢重。津气生于谷，谷气运于脾，脾湿不运，则津液不生而少气。小便难者，湿不行也。”

17.肾水者，其腹大，脐肿，腰痛，不得溺，阴下湿如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。

【论解】

本条是论述肾水的辨证。由于水寒盛于下，肾阳衰弱，不能温化水气，寒水增多，故其腹大，脐肿，腰痛。肾气不化，故不得溺，水气渗溢于前阴，故阴下冷湿，如牛鼻上汗。阳虚不温，故其足逆冷。肾阳虚，不能温暖脾胃，不能上会于头面，故面反瘦。

【选注】

《金匱要略直解》：“肾者胃之关也，关门不利，故令聚水而生病，是有腹大脐肿之证也。腰者肾之外候，故令腰痛。膀胱者肾之府，故令不得溺，不得溺则水气不得泄，渍于臑囊而为阴汗，流注于下焦而为足冷。夫肾为水藏，又被水邪，则上焦之气血，随水性而下趋，故其人面反瘦，非若风水、里水面目之洪肿也。”

18.师曰：诸有水者，腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗乃愈。

【论解】

本条是论述水气病的治疗法则。腰以上肿，多因风寒湿邪，侵于肌表，闭郁阳气，水湿停留而成。故治宜宣通肺气，发汗散邪，使肌表之水从汗液排出。腰以下肿，多因阳气衰弱，不能化气，水液凝聚，溢于肌表而成。故治宜化气行水，渗利水湿，使腰以下之水从小便排出。

水之去路有二：在表者发汗，在里专渗利，因势利导，使水气迅速而去。但临床所见，也有腰以上肿，而渗于里；腰以下肿，而溢于表，以致成为肺气不开，肾气不降，大气不转，发汗去其表邪，又要兼用渗利，使在里之水可以尽去；腰以下肿，既要渗利，又要兼开其肺，使上窍通而下窍利，则水气才能尽去。本条以发汗、利水为治水两大法门，以下又有温阳化气，健脾化湿，调和营卫，益气固表，行气散结，温经通阳等法，可称丰富多彩。

【选注】

《金匱要略心典》：“腰以下为阴，阴难得汗而易下泄，故当利小便；腰以上为阳，阳易外泄，故当发汗。各因其势而利导之也。”

19.师曰：寸口脉沉而迟，沉则为水，迟则为寒，寒水相搏，趺阳脉伏，水谷不化，脾气衰则鹜溏，胃气衰则身肿；少阳脉卑，少阴脉细，男子则小便不利，妇人则经水不通，经为血，血不利则为水，名曰血分。

【词解】

少阳脉：此指手少阳三焦经的“和髎”穴，在耳门之前上方，于耳廓根前，鬓发后缘处动脉应手。另有一种注解：右手尺脾为卑阴中之少阳。

脉卑：脉卑而弱，表示气血不足。

血分：妇女月经先停止，然后发生水肿病的名称。

少阴脉：指左手尺脉。

【诠解】

本条是论述水气病的病机，兼论妇人血不利的血分证。寸口脉以候肺气。由于肺之阳气虚弱，血脉运行不及，故寸口脉迟。肺气不能通调，水气逐渐凝聚，寒水内盛，阳气不能外达，故脉沉。阳虚水盛，溢于肌表形成水肿。

趺阳脉以候胃气。由于中阳衰微，故趺阳脉潜伏于里。脾胃衰弱，则水谷不化，脾衰而清气不升，故为鹜溏；胃衰外寒，浊阴不降，故水湿外溢而为身肿。

少阳脉以候三焦。由于三焦气弱血少，故少阳脉卑。三焦决渎功能失常，男子则小便不利，可以发展成为水肿。

少阴脉以候肾。由于妇人下焦寒邪凝结，脉道壅塞，故脉细。寒邪客于胞门，血寒而凝，故女子经水不通。经的来源是血，血行不利，渗出脉外而为水，月经不调可以形成水气病，故名曰“血分”。

【选注】

《金匱要略直解》：“沉为水，迟为寒，水寒相搏，则土败矣，是以胃之趺阳脉则伏，脾之水谷则不磨，脾衰则寒内着而为鹜溏，胃衰则水外溢而为身肿也。少阳者三焦也。《内经》曰：三焦者，决渎之官，水道出焉。今少阳脉卑，则不能决渎矣，在男子则小便不利。少阴者肾

也，《中藏经》曰：肾者女子以包血，以其与冲脉并行，今少阴脉细，则寒气客于胞门矣。在妇人则经水不通。经虽为血，其体则水，况水病而血不行，其血亦化为水，故名曰血分。”

20.问曰：病有血分、水分，何也？师曰：经水前断，后病水，名曰血分，此病难治；先病水，后经水断，名曰水分，此病易治。何以故，去水，其经其下。

【诠解】

本条是论述因经水断而病的“血分”和因水而病及血的“水分”。所谓血分，是由于经水前断，经血渗出脉外而为水。经水先断的原因：一为血脉壅塞不通，经水渗而为水，水湿外溢，身体四肢皆肿。又为脾胃亏损，不能运化水谷精微，血少而为经闭，水停而为水气。因血而病为水气，属瘀血者难化，属血虚者难补，故曰“此病难治”。

所谓水分，是由于先病水肿，水湿壅闭，经脉不畅，后经水断。治宜行水散湿，水去则经自通，其病可愈，故曰“此病易治”。

【选注】

《张氏医通》：“妇人经水先断，后至四肢浮肿，小便不通，通身皆肿，此血化为水，名曰血分。此病乃七情乖违，脾胃亏损不能统摄而成，最为难治，日用归脾汤下椒仁丸，药虽峻厉数日当效，畏而不用，有养病害身之患。若先小便不利，后至身面浮肿，经水不调者，血为水败也，名曰水分。用归脾汤送葶苈丸七丸。”

21.问曰：病者苦水，面目身体四肢皆肿，小便不利，脉之不言水，反言胸中痛，气上冲咽，状如炙肉，当微咳喘。审如师言，其脉何类？

师曰：寸口脉沉而紧；沉为水，紧为寒，沉紧相搏，结在关元，始时当微，年盛不觉。阳衰之后，荣卫相干，阳损阴盛，结寒微动，肾气上冲，喉咽塞噎，胁下急痛。医以为留饮而大下之，气击不去，其病不除，后重吐之。

胃家虚烦，咽燥欲饮水，小便不利，水谷不化，面目手足浮肿；又与葶苈丸下水，当时如小差。

食饮过度，肿复如前，胸胁苦痛，象若奔豚，其水扬溢，则浮咳喘逆。当先攻击冲气令止，乃治咳，咳止，其喘自差。先治新病，病当在后。

【词解】

苦水：苦，指程度重；水，指水气病。

脉之：诊病人之脉。

审如：审，是深入的观察；如，是确实如此。

关元：指脐下三寸部位。

气击：肾气向上冲击。

浮咳：水气上浮入肺而咳。

【诠解】

本条是论述水气病的传变和辨证论治。有的水气病人，面目身体四肢水肿，小便不利。老师诊脉之后，不谈水气，却说病人有胸中痛，气上冲咽，咽中感觉如有炙肉，有轻微咳喘。学生经过深入的观察，确实如此，老师怎样从脉象判断出来的？老师的判断如下：

由于寒水早已结于关元，有寒故脉紧，有水故脉沉。年轻阳气盛，寒水微弱，故不觉。中年之后，肾阳衰弱，寒水已盛，阴寒闭塞，营卫不通，寒水动而向上，又随肾气上冲，故见喉咽塞噎，胁下急痛。医生误认为是留饮病，而用下法，结果上冲之气既不能降，寒水又不能除。医生若用温暖肾阳，驱散寒水之法，则病无不去；医生又用吐法，损伤脾胃，胃阴虚少，故虚热而烦，咽燥欲饮食。脾胃气虚，运化失职，故水谷不化，小便不利。水气内停，故面目手足浮肿。医生没有料到冲气欲作之势，不知脾肾阳虚不能气化以制水本，只知水气内停，用葶苈丸下水，水肿稍见消退；若稍有不慎，如食饮过度，损伤脾胃，水气又起，故肿复如前。积水扬溢，随肾气上冲，水泛胸间，故胸胁苦痛。水气随冲气升浮入肺，故咳嗽喘逆。

本证治疗，应分两步，第一阶段先治新病。因冲气较急，故当先降其冲气，冲气平复，治咳嗽喘逆，咳喘平息之后，再治痼疾。第二阶段，既要温暖肾阳，驱散寒水，又要健脾益胃，恢复运化之职。本条说明，老师认识疾病，既从现在的脉证来认识，又从疾病的形成过程和误治后的变化，深刻的认识疾病。这样才能确定正确的治疗原则和阶段性的处理方法。

【选注】

《金匱要略心典》：“此水气先得，而冲气后发之证，面目肢体俱肿，咽喉噎塞，胸胁满痛，有似留饮，而实挟冲气也。冲气宜温降，不宜攻下，下之亦未必去，故曰气击不去，其病不除。医乃不知，而复吐之，胃气重伤，胃液因尽，故咽燥欲饮水，而小便不利，水谷不化，且

聚水而成病也，是当养胃气以行水，不宜径下其水。水虽下，终必复聚，故暂差而寻复如前也。水聚于中，气冲于下，其水扬溢，上及肺位，则咳且喘逆，是不可攻其水，当先止其冲气。冲气既止，然后水气可去，水去则咳与喘逆俱去矣。先治新病，病当在后者，谓先治其冲气，而后治其水气也。”

《医门法律》：“阳衰之后，结寒之邪发而上冲，医不治其冲气，妄吐下之，遂损其腐熟水谷传化津液之胃，于是渴欲饮水，小便不利。至积水四射，冲气乘虚愈击，尚可漫然治其水乎？故必先治冲气之本，冲气止，肾气平，则诸证自差。未差者各随所宜，补阳泻阴，行水实胃，疏通关元之积寒久痹可也。”

22.风水脉浮，身重，汗出恶风者，防己黄芪汤主之，腹痛者加芍药。

防己黄芪汤方方见湿病中。

【诠解】

本条是论述风水表虚的证治。由于风邪侵袭肌表，故脉浮。卫气虚不能固表，则汗出恶风。营卫涩水道不利，水留分肉，则身重。

治以防己黄芪汤，疏风益卫，利湿而健脾行水。方中防己散风邪，通腠理；黄芪补卫气，温分肉；白术健脾行湿；生姜散风湿；甘草、大枣调和营卫。腹痛者，为肝脾之血脉不和，故加芍药以调和肝脾。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“脉浮表也，汗出恶风，表之虚也；身重，水客分肉也。防己疗风肿，水肿，通腠理；黄芪温分肉，补卫虚；白术治皮风止汗；甘草和药益土；生姜、大枣辛甘发散。腹痛者，阴阳气塞，不得升降，故加芍药收阴。”

【病案举例】

刘某，女，56岁，工人，于1978年11月14日就诊。

患者有十余年的肾炎病史，近日因劳累过度复发。其面色^胱白，精神萎靡，头目昏晕，颜面浮肿，腰酸尿少。舌质淡，苔薄白，脉细无力。检查：慢性病容，营养不良，血压160/100毫米汞柱，心肺无异常，肝脾未触及，肾区有叩击痛。尿常规：蛋白（++），白细胞（+），颗粒管型（+），酚红试验50%。诊为慢性肾炎。此属脾肾两虚，水湿不化，聚而成肿，治以防己黄芪汤加味：汉防己、白术、仙灵脾各12克，黄芪、菟丝子、熟地、泽泻各15克，红枣、白茅根、怀牛膝

各30克，甘草5克。

服七剂后，浮肿已退。前方去泽泻，加杜仲12克，又服十剂后，诸恙均减。遂用左归丸每日服15克，黄芪粉每日口服6克。二月后，症状消失，血压、尿常规、酚红试验均正常，随访至今未复发。

（摘自《吉林中医药》1981,2:18）

23.风水，恶风，一身悉肿，脉浮，不渴，续自汗出，无大热，越婢汤主之。

越婢汤方

麻黄六两 石膏半斤 生姜三两 甘草二两 大枣十五枚

上五味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

恶风者，加附子一枚，炮。

风水，加术四两《古今录验》。

【诠解】

本条是论述风水挟热的证治。由于风邪袭于肌表，故恶风。肺的治节不利，决渎失司，水溢皮肤，故一身悉肿。风客于表，气血向外，故脉浮。病在表，故不渴。风性疏泄，汗出则阳郁不甚，故无大热。

治以越婢汤，发散风湿，清解郁热。方中麻黄、生姜发越阳气，宣散水湿；石膏清解郁热；甘草、大枣调和脾胃荣卫。恶风者，为卫阳虚，则加附子温之；风水加白术补脾以化湿。

【选注】

《金匱要略编注》：“此风多水少之证也。风多伤表，外应肌肉，内连及胃，故恶风一身悉肿。胃气热蒸，其机外向，不渴而续自汗出。无大热者，则知表有微热而为实也。故以麻黄通阳气而散表；石膏入胃，能治气强壅逆风化之热；甘草、姜、枣以和荣卫。若恶风者，阳弱而为卫虚，故加附子。”

24.皮水为病，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者，防己茯苓汤主之。

防己茯苓汤方

防己三两 黄芪三两 桂枝三两 茯苓六两 甘草二两

上五味，以水六升，煮取二升，分温三服。

【词解】

聂聂：如树叶被风吹动之状，这里形容微微抽动。

【诠解】

本条是论述皮水气虚的证治。由于脾阳虚弱，水湿内停，里水外溢。肺气不足，通调无力，水湿在皮中停滞，故四肢肿，按之没指。水湿壅遏卫气，气行逐水，水气欲行不行，则四肢聂聂动。

治宜防己茯苓汤，健脾益肺，行水利湿。方中防己、茯苓通行皮表，渗湿利水，导水下行；黄芪、桂枝益气温阳，以助行水化水之力；甘草配黄芪、茯苓，健脾益肺，恢复运化通调之功。

【选注】

《金匱要略心典》：“皮中水气，浸淫四末，而壅遏卫气，气水相逐，则四肢聂聂动也。防己、茯苓善驱水气，桂枝得茯苓，则不发表而反行水，且合黄芪、甘草，助表中之气，以行防己、茯苓之力也。”

《金匱要略编注》：“此邪在皮肤而肿也，风入于卫，阳气虚滞，则四肢肿。皮毛气虚受风而肿，所谓水气在皮肤中，邪正相搏，风虚内鼓，故四肢聂聂动，是因表虚也。”

25.里水，越婢加术汤主之，甘草麻黄汤亦主之。

越婢加术汤方

见上。于内加白术四两，又见中风中。

甘草麻黄汤方

甘草二两 麻黄四两

上二味，以水五升，先煮麻黄，去上沫，内甘草，煮取三升，温服一升，重复汗出，不汗再服，慎风寒。

【词解】

里水：即前一身面目黄肿、脉沉、小便不利之证。

【诠解】

本条是论述里水一证两方的治法。里水是由于脾阳虚不能运化水湿，肺气虚不能通调水道，水湿停留，泛于肌表而成。里水湿郁滞化

热，一身面目黄肿者，可用越婢加术汤健脾宣肺而清郁热。若水湿停于肌表，无热而身肿者，可用甘草麻黄汤，内助脾气，外散水湿，使腰以上肌表寒水从汗而去。

【选注】

《医宗金鉴》：“皮水表虚有汗者，防己茯苓汤固所宜也；若表实无汗有热者，则当用越婢加术汤；无热者，则当用甘草麻黄汤发其汗，使水外从皮去也。”

《金匱要略浅注》：“一身面目黄肿，谓之里水，乃风水深入肌肉，非脏腑之表里也。腠实无汗，胃热向内，欲迅除其热，越婢加术汤主之；欲迅发其汗，甘草麻黄汤亦主之。”

26.水之为病，其脉沉小，属少阴。浮者为风；无水，虚胀者为气。水，发其汗即已。脉沉者宜麻黄附子汤，浮者宜杏子汤。

麻黄附子汤方

麻黄三两 甘草二两 附子一枚，炮

上三味，以水七升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取二升半，温服八分，日三服。

杏子汤方

未见。恐是麻黄杏仁甘草石膏汤。

【诠解】

本条是论述正水、风水与虚胀的鉴别，及正水与风水的治法。正水病由于少阴肾阳不足，不能温化水气，水气停蓄于中，故腹满。水气上逆于肺，故喘息。肾阳不足，故脉沉小。治宜麻黄附子汤。方中麻黄宣肺发汗，祛水平喘；甘草健脾制水，附子温阳化湿。

风水病由于风邪侵袭肌表，故脉浮而恶风。肺失通调之职，水湿停滞，留于体表四肢关节，故头面浮肿，骨节疼痛。治以杏子汤。方中麻黄开宣肺气，散风湿；杏仁开肺气，利水湿；甘草和中。

虚胀病由于肺气郁而不行，气郁而胀。虚胀病无水而有气，故治以

补肺行气。

【选注】

《金匱要略心典》：“水气脉沉小者属少阴，言肾水也；脉浮者为风，即风水也。其无水而虚胀者，则为气病而非水病矣。气病不可发汗，水病发其汗则已。然而发汗之法，亦有不同。少阴则当温其经，风水即当通其肺，故曰脉沉者宜麻黄附子汤，脉浮者宜杏子汤，沉谓少阴，浮谓风也。”

27.厥而皮水者，蒲灰散主之方见消渴中。

【论解】

本条是论述内有郁热，阳气不达四肢的辨证论治。由于脾肺气虚，不行津液，故渴。湿热内郁，水气行于皮中，则不恶寒，身肿而冷，状如周痹。水在皮中，痹阻阳气，阳气不达于四肢，故手足厥冷。

治以蒲灰散利水通阳。方中滑石利水泻郁热，郁热一去，阳气可行；生蒲黄炒黑，行瘀通络，利水消肿，阳气通达，诸证可愈。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“厥而皮水者，厥为阳虚阴盛之证，但在皮水中，则非宗阳内虚之证，而乃卫阳外虚之厥也。皮之水邪既盛，必溢于四肢，周身之卫气凝滞不行矣，故令得厥，非必里阳已微，方见厥逆也。此厥之因水而成者，治其水而厥可愈。主之以蒲灰散，祛水即用利水之法，水去而卫气得行于皮肤，四肢可以回温而厥亦已矣。”

28.问曰：黄汗之为病，身体肿一作重，发热汗出而渴，状如风水，汗沾衣，色正黄如蘘汁，脉自沉，何从得之？师曰：以汗出入水中浴，水从汗孔入得之，宜芪芍桂酒汤主之。

黄芪芍药桂枝苦酒汤方

黄芪五两 芍药三两 桂枝三两

上三味，以苦酒一升，水七升，相和煮取三升，温服一升，当心烦，服至六七日乃解。若心烦不止者，以苦酒阻故也。一方用美酒醯代苦酒。

【词解】

苦酒：即醋。

醢：酸味之汁液。

【诠解】

本条是论述黄汗病的辨证论治。由于汗出入水中，寒水从汗孔侵入，郁遏汗液，水湿留于肌肉经脉，阻碍营卫的运行，卫郁不能行水，故全身水肿；营郁而热，积热成黄，湿热外蒸，故发热，汗出，汗沾衣，色正黄如柏汁。气不化津，故口渴。卫阳不利，故脉沉。治以芪芍桂酒汤，调和营卫，畅达气血。方中桂枝温化通行肌表水湿；生黄芪温行卫阳，补益脾肺之气；芍药清营血之热，行营血之郁；苦酒泄营中郁热。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“以汗出入水中浴，水从汗孔入得之，是寒湿伤于血分，而非风邪伤于气分也。汗属血，为水湿之寒邪所郁，则内变热而色黄，如《伤寒论》所言：湿热内瘀则发黄也。然彼湿热内瘀，又不专在血分，其湿热内瘀者里分也，而发黄者表分也，在里则气血兼有，而在表必营卫兼有也。今黄汗之证，专在血分，故汗出之色黄而身不黄，又与发黄之证不同也；更与风水、皮水，风寒外感之气分大不同也。仲景主之以芪芍桂酒汤，用黄芪补气固表；芍药、苦酒治在血分，引桂枝入营驱其水湿之邪。一方而专血分兼表里，其义备矣。服后心烦，仍服勿疑，以苦酒湿热，未免与湿邪相阻，然非此无以入血而驱邪。所谓从治之法也。至六七日湿邪渐除，苦酒之湿无所阻，而心烦自止矣。”

【病案举例】

周某，女，48岁，邹平县社员，1979年6月初诊。去年深秋，劳动结束后，在小河中洗澡，受凉后引起全身发黄浮肿，为凹陷性，四肢无力，两小腿发凉怕冷，上身出汗，下身不出汗，汗发黄，内衣汗浸后呈淡黄色，腰部经常串痛，烦躁，下午低烧，小便不利。检查：肝脾未触及，心肺听诊无异常，血、尿常规化验正常，黄疸指数4单位，蛋白电泳：白蛋白47.8、 α_1 6.4、 α_2 7.8、 β 14、 γ 24，脉沉紧，舌苔薄白。服芪芍桂酒汤：黄芪30克，桂枝18克，白芍18克。水二茶杯，米醋半茶杯，头煎煮取一杯；二煎时加水二杯，煮取一杯，头煎液和二剂液合在一起，分为二份，早晚各一份。共服六剂，全身浮肿消退。皮肤颜色转正常，纳增。疗后未复查蛋白电泳。

（摘自《山东中医学院学报》1980,2:55）

29.黄汗之病，两胫自冷，假令发热，此属历节；食已汗出，又身常暮卧盗汗出者，此荣气也；若汗出已，反发热者，久久其身必甲错；发热不止者，必生恶疮；若身重汗出已，辄轻者，久久必身**𦐇**，**𦐇**即胸中痛，又从腰以上必汗出，下无汗，腰髋弛痛，如有物在皮中状，剧者不能食，身疼重，烦躁，小便不利，此为黄汗，桂枝加黄芪汤主之。

桂枝加黄芪汤方

桂枝 芍药各二两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚 黄芪二两

上六味，以水八升，煮取三升，温服一升，须臾，饮热稀粥一升余，以助药力，温复取微汗，若不汗更服。

【词解】

荣气：指劳病热在荣分。

恶疮：即痈脓。

身**𦐇**：身体**𦐇**动。

腰髋弛痛：腰髋部无力而疼痛。

【论解】

本条是论述黄汗病的证治，以及黄汗病与历节病、荣气病的鉴别。“假令发热，此属历节”，说明历节病是由于风寒湿邪侵入机体，遍历关节，湿邪化热，流入关节，故历节病者身热两足亦热。“食已汗出，又身常暮卧盗汗出者，此荣气也。”说明荣气病是由于气虚表不能固，食后微热则汗出，或阴虚内热而外蒸，常暮卧盗汗出。

黄汗病，是由于汗出阳气外发，营阴外泄，营卫不和之时，水气乘虚侵入，阴湿积于下焦，卫阳虚弱，故两胫自冷，腰以下无汗，腰髋弛痛，如有物在皮中状，身疼而重。阳气虚弱，不能温脾，故剧者不能食。不能温阳化气，故小便不利。心火不能下交，独居于上，心火蒸腾，故发热，烦躁，腰以上汗出。若阳气太盛，汗出已反发热者，必然耗损营血，不能濡养皮肤，故其身必甲错。热郁肌肉，腐肉化脓，则生恶疮。若汗出后，湿热减轻，阳气亦虚，待阳气恢复，欲行水气，水气欲行不行，故必身**𦐇**动。上焦湿气不行，下焦阴湿闭塞，气机不畅，故

胸中疼痛。

本证为阴湿积于下焦，湿热壅于上焦，荣卫之气不能循行上下，阳火独壅于上，积热成黄，故为黄汗病。

治以桂枝加黄芪汤，调和营卫。方中桂枝温阳行水；芍药泄心火，敛阴气；桂枝、芍药调和阴阳，升下焦阳气以散寒湿，寒湿一去，心火下交于肾，上下交通，内外畅达；黄芪伸展阳气，固表敛阴；生姜、大枣、甘草调和营卫；饮热稀粥以助药力，取微微汗出，湿邪渐渐散去。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“黄汗病由阴阳水火不既济，阴阳者，荣卫之主，荣卫者，阴阳之用，阴阳不既济，而荣卫亦不循行上下，阳火独壅于上为黄汗，阴水独积于下致两胫冷。”

《张氏医通》：“黄汗皆由荣气不和，水气乘虚袭入，所以有发热汗出，身体重痛，皮肤甲错，肌肉^𦵏动等证。至于胫冷髀弛，腰以下无汗，《内经》所谓身半以下，湿中之也。脉沉迟者，水湿之气渗于经脉，而显迟滞不行之状，证虽多歧，观其所治，咸以桂芍和荣散邪，即兼黄芪司开合之权，杜邪复入之路也。案仲景于瘀热壅泄之候，每云甲错，即肌若鱼鳞之状，故发热不止，则瘀热溃腐而为恶疮。每言身^𦵏乃经脉动惕之兆，故发汗不已，则荣气内乏，而胸中痛也。”

30.师曰：寸口脉迟而涩，迟则为寒，涩为血不足；趺阳脉微而迟，微则为气，迟则为寒，寒气不足，则手足逆冷，手足逆冷，则荣卫不利，荣卫不利，则腹满胁鸣相逐；气转膀胱，荣卫俱劳；阳气不通，即身冷，阴气不通即骨疼；阳前通则恶寒，阴前通则痹不仁，阴阳相得，其气乃行，大气一转，其气乃散，实则失气，虚则遗溺，名曰气分。

【词解】

大气：指宗气而言。

气分：寒邪病于气分。

【诠解】

本条是论述气分病的病机和症状，而与血分病对比发明。由于脾胃虚寒，则趺阳脉微而迟。脾阳不暖四肢，则手足逆冷。脾胃虚寒，营卫无源，血寒而少，则寸口脉迟而涩。脾阳虚，血涩少，荣卫不利，寒积中焦不散，则腹满肠鸣相逐，夫肠实便燥则矢气。今营卫劳损俱甚，寒气传于下焦膀胱，与气虚不能收涩，则遗溺。阴寒积于下焦，阳气不

通，则身冷，恶寒；阴血不行，则骨节疼痛，肌肤麻痹不仁。

本条所论气寒则凝而不通，因脾胃虚寒则荣卫不利。中焦寒气转甚，可传于下焦，传于肌肉、骨节。治疗原则是温通阳气，补益阴血，使阴阳相得，其气乃行，水谷之气积于胸中者，名曰大气，一旦转流全身，其阴寒之气可以消散，则气分之病可愈。

【选注】

《医宗金鉴》：“寸口脉迟为寒，脉涩少血；趺阳脉微乏气，迟亦为寒，是则气血俱虚，为寒气所干，营卫不利，阴阳不通，故身寒骨疼，手足逆冷，腹满肠鸣，恶寒麻痹，矢气遗溺也。此气血俱虚，寒气内客之气胀，故曰气分。”

31.气分，心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作，桂枝去芍药加麻辛附子汤主之。

桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤方

桂枝三两 生姜三两 甘草二两 大枣十二枚 麻黄 细辛各二两 附子一枚，炮

上七味，以水七升，煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取二升，分温三服，当汗出，如虫行皮中即愈。

【词解】

旋杯：即圆杯。

【诠解】

本条是论述心肾阳虚气分病的证治。由于心阳不足，肾阳微弱，阳虚不能温化，心阳不能下，肾阳不得升，阴寒水饮凝聚，积留胃中，则胃脘痞结而坚，以手触之则如盘如杯。阴寒聚于中，常见腹满肠鸣。阳虚不能温暖，常见手足逆冷，身冷，骨节疼痛。

治以桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤，温阳散寒，通利气机。方中桂枝温通心阳，温化水湿；附子温暖肾阳，蒸化水气；细辛温经散寒，消散水饮；麻黄宣通肺气，通畅水道；生姜、甘草、大枣温脾和胃，调和营卫。服温药取汗，气机调畅，寒水消散，诸证可除。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“此证是心肾交病，上不能降，下不能

升，日积月累，如铁石之难破。方中用麻黄、桂枝、生姜以攻其上；附子、细辛以攻其下；甘草、大枣补中焦以运其气。庶上下之气交通，而病可愈，所谓大气一转，其结乃散也。”

32.心下坚，大如盘，边如旋盘，水饮所作，枳术汤主之。

枳术汤方

枳实七枚 白术二两

上二味，以水五升，煮取三升，分温三服，腹中软，即当散也。

【诠解】

本条是论述脾胃虚弱的气分病证治。由于脾胃虚弱，不能升清降浊，阴寒水饮结聚，留于胃中，故心下坚，大如圆盘。

治宜枳术汤健中消痞。方中白术健中，升清降浊，消散寒水；枳实行气泄水，消坚散痞。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“心下，胃上脘也。胃气弱则所饮之水入而不消，痞结而坚，必强其胃乃可消痞。白术健脾强胃；枳实善消心下痞，逐停水，散滞气。”

【病案举例】

张某，男，51岁，干部。1980年5月初诊。胃脘痞满时痛四五年，饮食后加剧，大便时干时溏，经西安市某医院X线检查诊断胃下垂（低于髂联线7~8厘米），脉缓弱，左关脉弦缓，苔白润，乃脾虚水停所致。拟健脾行水消痞，以枳实汤加味：

枳实20克，白术20克，川厚朴10克，青皮10克，砂仁5克，甘草5克，广木香5克。在此方基础上加減服药三个多月，共服药40余剂，于1980年9月再次作X线钡餐透视，胃下极已上升至髂联线以上，胃脘痞满痛也基本消失。

（摘自《陕西中医》1981,3:43）

附方

《外台》防己黄芪汤

治风水，脉浮为在表，其人或头汗出，表无他病，病者但下重，从腰以上为和，腰以下当肿及阴，难以屈伸方见风湿中。

【诠解】

本方是论述风水在下的证治。由于下焦阳气不振，外感风湿，风水下重上轻。心阳不能向下而郁蒸于上，故脉浮头汗出。头汗出则腰以上风水病和缓。凡水下重，湿从下起，上溢于腹，故腰下沉重，水肿，阴部亦肿，难以屈伸。

本证上轻下重，上有郁热，下有寒水，风少湿多，故用防己黄芪汤，益气除湿，调和营卫。方中防己宣通肺气，通调水道，降气泄火，水去火降，上下皆和；黄芪强卫固表，使汗孔开合正常，可止头汗，可泄水气；黄芪配防己，益气行水，行在下肌表之水气；白术健脾化湿，使脾胃升降得宜，配黄芪而升清阳，合防己而降浊阴；甘草健中化湿，调肺气输布津液；生姜走窜，温阳行水，消散水气，通阳助卫；大枣安中，补脾益阴，生化气血，入血和营，姜枣相配在内调和脾胃，在外和其营卫。

【选注】

《金匱要略编注》：“此乃湿从下受，湿多风少，故用黄芪实表，使水不得上溢；以防己驱除风湿；甘草健脾，姜枣以俾荣卫和而湿自除矣。”

结语

本篇详细地论述水气病的病因、病机和辨证论治。水肿形成的机理，是由于肾阳虚不能气化，脾气虚不能运化，肺气虚不能通调，以致水湿之邪不得消散而停聚为病。

水气病的辨证论治，腰以上肿，可用发汗等方法；腰以下肿，可用利小便等方法，因势利导为其基本治则。因水气停聚部位不同，可分风水、皮水、正水、石水。风水的治疗，若属风水表气已虚的，可用防己黄芪汤益气散湿，健脾行水；风水挟热，可用越婢汤发散风湿，清解郁热；风邪侵袭肌表，有脉浮等表证的风水，可用杏子汤解表开肺，利湿和中。皮水的治疗，若属皮水气虚的，可用防己茯苓汤，健脾益肺，行

水利尿；皮水内有郁热，阳气不达四肢，可用蒲灰散；里水气虚郁热者，可用越婢加术汤，健脾利肺，清泄郁热；里水无热者，甘草麻黄汤补中宣肺。正水的治疗，属阳虚不温的，可用麻黄附子汤，温阳健脾，宣通肺气。石水的治疗，虽无方药，可辨证明确，选用温暖脾肾，疏通肝络之方即可。

黄汗病因湿热郁于心营，积热成黄，汗出色黄而得名。若属水寒郁卫，营分有热的黄汗病，可用芪芍桂酒汤调和营卫，畅达气血；若属阴寒积于下，阳火郁于心而成的黄汗病，可用桂枝加黄芪汤调和营卫，交通上下。黄汗病的治疗，既要以温药调和，又要以黄芪强其卫气。

气分病因阳气虚弱，气机不畅，阴寒结聚，水留胃中而成。若属心肾阳虚，不得升降者，可用桂枝去芍药加麻辛附子汤，温阳散寒，通利气机；若属脾胃虚弱，升降失常者，可用枳术汤健中消痞。

黄疸病脉证并治第十五

概说

本篇是论述黄疸病的辨证论治。篇中共有条文二十二条，载方六首，附方一首。其中第一条至第十条论述了黄疸病的病因、病理、证候、分类、辨证和治则。第十一、十二条是论黄疸病的预后情况和治疗上的难易。第十三条至第二十二条阐述了黄疸病的治疗和方药。

黄疸病是以面目一身黄染，尿色赤黄，或大便灰白为主证。黄疸病又分为湿热发黄、寒湿发黄，以及脉浮而黄、火劫而黄、燥结而黄、女劳而黄，以及虚劳发黄等等。其中以湿热蕴结，胆汁失常所发生的黄疸，临床较为常见。

根据黄疸不同的发病原因和证候，本篇又分有谷疸、酒疸、女劳疸之名。谷疸，是由脾胃湿热郁蒸，或寒湿郁结所致。酒疸，是因饮酒过度，酒湿内蕴所引起。女劳疸，则是肾劳热在阴分之所致。

在治疗方面，有解表发汗，通利小便，清泻湿热，润燥滋血，调补脾胃的各种方法。

1.寸口脉浮而缓，浮则为风，缓则为痹，痹非中风；四肢苦烦，脾色必黄，瘀热以行。

【词解】

寸口脉：在这里是包括两手寸关尺而言。

痹非中风：痹是瘀阻不通的病机，非中风不遂之证。

【诠解】

本条是论述黄疸病的发病机理。脉浮则为风，当作有热理解。缓则为痹，当作有湿理解。湿热相合，痹郁于脾，脾主四肢，故四肢苦于热烦。脾土也，土色为黄，故湿热外现，一身尽黄，乃瘀阻之热所致，故曰“瘀热以行”。

【选注】

《金匱要略直解》：“脉得浮缓者，必发黄，故伤寒脉浮而缓者，系在太阴。太阴者，必发身黄。今浮为风，缓为痹，非外证之中风，乃风热蓄于脾土，脾主四肢，故四肢苦烦，瘀热行于外，则发黄也。”

2. 趺阳脉紧而数，数则为热，热则消谷，紧则为寒，食即为满。尺脉浮为伤肾，趺阳脉紧为伤脾，风寒相搏，食谷即眩，谷气不消，胃中苦浊，浊气下流，小便不通，阴被其寒，热流膀胱，身体尽黄，名曰谷疸。额上黑，微汗出，手足中热，薄暮即发，膀胱急，小便自利，名曰女劳疸，腹如水状，不治。心中懊憹而热，不能食，时欲吐，名曰酒疸。

【词解】

消谷：是指能食善饥。

苦浊：苦，有甚的意思。浊，指湿邪而言，即胃里的湿热太甚。

薄暮：迫近日暮的时刻。

【论解】

本条是进一步论述黄疸的病机，以及黄疸的分类。谷疸的病机是趺阳脉浮而数，数为胃中有热，胃热亢盛，故能消谷善饥；紧为脾之寒湿，脾寒则运化不及，能食而不能运，故食后谷留即为腹满。胃热脾寒湿，以致中焦的转输和气化功能失常，而使湿热相搏结于中焦。此时若饮食入胃，反助其热，湿热上蒸，清阳之气不得上升，故出现头眩；水谷不消，湿热蕴郁更重，故胃中苦浊郁闭不舒，湿热下注膀胱，膀胱气化受阻，故小便不利，则尿黄而涩少。湿热不能排泄，必然郁滞于内，熏蒸肝胆，迫使胆汁外溢，故成谷疸病症。

“尺脉浮为伤肾，趺阳脉紧为伤脾。”是对比女劳疸与谷疸的脉象差异而言。女劳疸是由于肾阴亏损，阴虚火旺，故尺脉见浮。谷疸是因脾停湿邪，化热下注，故而脉紧。

“阴被其寒，热流膀胱。”是总结谷疸的病机。寒字当邪字体体会，是说阴脏受邪，而热流膀胱的病理过程，也是谷疸发黄的要害。

女劳疸是因房室伤肾，阴虚火旺所致。肾劳而热，黑色上出，犹脾病而黄外见，故额上黑；肾热上行，而气通于心，则微汗出；手足心热，薄暮即发，病在阴而有热也；膀胱急者，为肾热所逼也；小便自利者，与湿无关也。此得之女劳，其疸色黑而目不黄，故与酒疸异也。若腹如水状，则不特伤阴，阳气亦随之而亡，故曰不治。酒、色伤人，可

不慎欬。

酒疸是由饮酒过度，湿热郁蒸中官，熏灼于心，所以心中懊^怏而热。湿热内盛，升清降浊之机受阻，胃气上逆，故不能食，时时恶心欲吐。湿热熏蒸肝胆，胆汁外溢肌表而身黄，故名酒疸。

由上可知，谷疸、酒疸皆因于湿，湿性滞，故小便不利，而女劳疸则因于劳热，无关于湿，故小便自利。

【选注】

《金匱要略浅注》：“此言趺阳脉，以明胃热脾寒，郁而成疸。又言肾脉浮，趺阳脉紧，为肾热脾寒，亦能郁而成疸。又归于膀胱之不化气，以膀胱主一身肌表，不化气则湿热无去路，而亦成疸。其病虽有各经之不同，而总以脾胃为主，故以谷疸结之。”

《金匱要略心典》：“趺阳脉数为热者，其热在胃，故消谷；脉紧为寒者，其寒在脾，故满，满者必生湿，胃热而脾湿，亦黄病之原也。尺脉浮为伤肾者，风伤肾也；趺阳脉紧为伤脾者，寒伤脾也，肾得风而生热，脾得寒而生湿，又黄病之原也。湿热相合，其气必归脾胃，脾胃者，仓廩之官也；谷入而助其热则眩，谷不消而气以瘀，则胃中若浊，浊气当出下窍。若小便通，则浊随溺去，今不通，则浊虽下流而不外出，于是阴受其湿，阳受其热，转相流被而身体尽黄矣。曰谷疸者，病虽始于风寒，而实成于谷气耳。”

3.阳明病脉迟者，食难用饱，饱则发烦，头眩，小便必难，此欲作谷疸；虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

【词解】

食难用饱：不敢吃的太饱。

【诠解】

本条是论述阳明湿热欲作谷疸的病证。谷疸多属湿热，故脉来迟缓；湿热阻于中焦，消化不及，故食难用饱；饱则谷气郁滞不化，则见腹满。谷入增热，所以发烦。浊热上蒸，阻遏清阳，故见头眩。湿热下阻，三焦不利，故小便难。湿热既无外出之机，势必阻遏肝胆疏泄，乃为谷疸之由。治当利小便以去湿，不可误用泻下以去实。因无实可下，故虽下之，而腹满如故。此虽言不可下之理，并亦为“虽下之”，指出了腹满的误诊。“所以然者，脉迟故也”是自注句，说明脉迟主湿而非燥。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉迟胃弱，则谷化不速；谷化不速，则谷气

郁而生热，而非胃有实热，故虽下之而腹满不去。伤寒里实，脉迟者尚未可攻，况非里实者耶。”

4.夫病酒黄疸，必小便不利，其候心中热，足下热，是其证也。

【诠解】

本条论述酒疸的辨证。由于耽嗜酒麴，以致湿热郁于中焦，脾胃不能升清降浊，湿热上蒸，故心中热。湿热下流，膀胱气化受阻，必见小便不利。湿热流注于下，故足下热。湿热不能外泄，郁蒸于内，故发黄。

酒疸的“足下热”与女劳疸的“手足中热”，两者颇相近似，酒疸是因湿热下注所致，故兼小便不利。女劳疸是肾虚有热引起，故小便自利。虽两证相近似，但机理不同，须加鉴别。

【选注】

《金匱要略直解》：“小便利则湿热行，不利则热留于胃，胃脉贯膈下足跗，上熏胃脘则心中热，下流足跗则足下热也。”

5.酒黄疸者，或无热，靖言了，腹满，欲吐，鼻燥，其脉浮者先吐之，沉弦者先下之。

【词解】

靖言了：是指语言清晰，神情安静。

【诠解】

本条是论述黄疸的证治。由于湿热蕴郁脾胃，气机失常，病变可有在上，在中，在下之分。如果湿热尚未熏蒸于上，则心中无热，心神宁静，语言不乱；如果湿热中阻不行，浊气内聚，又向上逆，则腹满欲吐；湿热耗阴，上熏于肺，则鼻燥。本证为湿热居中，有向上向下之势。若脉浮者，湿邪趋向于上，因势利导，用吐法治之。若脉沉弦者，是湿邪趋向于下，故用下法治之。

本条是通过脉象论述黄疸病的证治方法。正气抗邪有向上向下的自然趋势，治则应因势利导，可收事半功倍之效。条文中有“先吐”、“先下”之说，言外之意，吐和下尚不能尽除其病，须要再辨证治疗。

【选注】

《金匱要略论注》：“然酒疸变证，亦有热去于心而无热，且靖言了了，其邪竟注于阳明而腹满欲吐鼻燥者。邪苟近上，脉必浮，宜吐之；邪苟近下，脉必沉弦，宜下之。盖治阳明惟有吐下两法也。曰先者

倘有未尽之病，再消息也。”

6.酒疸，心中热欲吐者，吐之愈。

【诠解】

本条是论述酒疸欲吐的治法。由于湿热内阻中焦，气机不畅，湿热邪气上冲，故心中热欲吐。因湿邪有向上之势，故用吐法，涌出病邪。

【选注】

《金匱要略论注》：“酒疸心中热，方恶其结热不行，假使欲吐，正热邪欲出之机，故曰吐之愈。”

7.酒疸下之，久久为黑疸，目青面黑，心中如啖蒜虀状，大便正黑，皮肤爪之不仁，其脉浮弱，虽黑微黄，故知之。

【词解】

心中如啖蒜虀状：如吃蒜虀样，心中有辛辣的灼热感。

爪之不仁：爪，当动词解，即搔抓皮肤时，对痛痒不敏感。

【诠解】

本条论酒疸误治的变证。酒疸尚未成实，而反用下法，下伤脾胃，胃伤则湿热更重，久久则由黄变黑，成为黑疸。黑疸者，血中湿盛而成瘀也，故目青面黑，大便色黑。若湿热互蒸，熏灼中焦，故心中如啖蒜虀状。血瘀则皮肤失禀，则爪之不仁。本病仍是湿热酒疸，故疸色虽黑，而带有微黄，与女劳疸则异。

根据临床观察，凡黄疸日久不退，而湿热甚者，皆能变为黑疸，亦不可不知。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“酒疸之黑，非女劳疸之黑也。女劳疸之黑，肾气所发也；酒疸之黑，败血之黑也。因酒之湿热伤脾胃，脾胃不利，阳气不化，阴血不运，若更下之，久久则运化之用愈耗矣。气耗血积故腐瘀，浊色越肌面为黑；味变于心咽作嘈杂，心辣如啖蒜虀状；荣血衰而行于皮肤，爪之不仁，输于大肠，便如黑漆。其目青与脉浮弱，皆血病也。”

8.师曰：病黄疸，发热烦喘，胸满口燥者，以病发时，火劫其汗，两热所得，然黄家所得，从湿得之。一身尽发热，面黄，肚热，热在里，当下之。

【词解】

肚热：即腹中热。

【诠解】

本条论述用火劫发黄的证治。本病的初期为里有湿热，当用清热利湿之法。若误用火劫发汗以退其黄，则使在里之湿热不得解，反使火邪与郁热相合，则两热相得。邪热上壅，故发热烦喘，胸满口燥，然邪热虽盛，无热则不黄，故曰“然黄家所得，从湿得之”，使人“一身尽发热，面黄，肚热”，此为黄疸的里热实证，故当下之。

【选注】

《金匱要略心典》：“烦、满、燥、渴，病发于热，而复以火劫之，以热遇热，相得不解，则发黄疸；然非内兼湿邪，则热与热相攻，而反相散矣，何疸病之有哉。故曰：黄家所得，从湿得之，明其病之不独因于热也。而治此病者，必先审其在表、在里，而施或汗、或下之法；若一身尽热而腹热尤甚，则其热为在里，里不可从表散，故曰当下。”

9.脉沉，渴欲饮水，小便不利者，皆发黄。

【诠解】

本条论述湿热黄疸的辨证。由于湿热郁滞于里，故脉见沉。渴欲饮水，是里有热邪，若热从燥化，则大便必硬；若热从湿化，则小便不利。热郁蒸邪无从外出，势必影响胆液排泄失常，而为黄疸。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉沉者，热难外泄，小便不利者，热不下出，而渴饮之水，与热相得，适足以蒸郁成黄而已。”

10.腹满，舌痿黄，躁不得睡，属黄家舌痿疑作身痿。

【词解】

舌痿黄：是指舌黄而不红润。

【诠解】

本条论述黄疸病属湿重于热的辨证。脾主腹，脾之脉又连舌本，若腹满舌痿黄，是脾有湿而不散；又躁不得睡，主胃有热而卧不安。湿热相加，病属黄家则何疑之有？

【选注】

《金匱玉函经二注》：“若舌痿黄燥者亦有说。心脾脉络舌上下，

凡舌本黄燥，即是内热，况舌痿乎？湿热结积虽不行肌表，然已见于舌，即属黄家也。”

11.黄疸之病，当以十八日为期，治之十日以上瘥，反剧为难治。

【诠解】

本条论黄疸的预后。黄疸是因脾湿为病。脾土在自然气候之中，旺于四季之末各十八天。所以此十八天为脾土之旺日，脾病在其气旺之时则容易治愈，故以十八天为期。也就是说，十八天之内治疗病势有所减轻，就容易治愈。如果十天之后，病情反加严重，则为邪盛正虚，由急性转为慢性，在治疗上就比较困难。

本条总的精神，说明黄疸的预后在时间上很为重要。也说明争取及早治疗，以防日久正衰邪盛，难以痊愈之意。

【选注】

《金匱要略心典》：“土无定位，寄旺于四季之末各十八日。黄者，土气也；内伤于脾，故即以土旺之数，为黄病之期。盖谓十八日脾气至而虚者当复，即实者亦当通也。治之十日以上差者，邪浅而正胜之，则易治；否则，邪反胜正而增剧，所谓病胜脏者也，故难治。”

12.疸而渴者，其疸难治；疸而不渴者，其疸可治。发于阴部，其人必呕；阳部，其人振寒而发热也。

【词解】

阴部：阴部为在里，阳部则为在表。

【诠解】

本条亦论黄疸的预后。黄疸病是湿热郁蒸之证。若疸而渴者，主里热重，热重则湿留，故为难治。反之，疸而不渴者，主里热式微，湿则无援，故易治愈。发于阴部，阴主里，里病则气逆，故其人必呕。发于阳部，阳主表，表有邪，则其人振寒而发热。

以上十二条论述黄疸病的病机、分类、禁忌、预后和治疗原则等，故带有总论意义。

【选注】

《金匱要略心典》：“疸而渴，则热方炽而湿且日增，故难治；不渴，则热已减而湿亦自消，故可治。阴部者，里之脏腑，关于气，故呕；阳部者，表之躯壳，属于形，故振寒而发热。此阴阳、内外、浅深、微甚之辨也。”

13.谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄，为谷疸。茵陈蒿汤主之。

茵陈蒿汤方

茵陈蒿六两 栀子十四枚 大黄二两

上三味，以水一斗，先煮茵陈，减六升，内二味煮取三升，去滓，分温三服，小便当利，尿如皂角汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

【诠解】

本条论述湿热谷疸的证治。本证由于脾胃湿热，湿热交蒸，营卫之气，壅塞不利，故发热恶寒；湿困脾胃，不能运化，故不能食。若多进食，助其湿热，湿热内聚，不得下行，故心胸不安。湿热邪气上冲，故食即头眩。湿热阻遏气化，故尿黄而少。湿热无从排泄，持续日久，势必增盛，熏蒸肝胆，胆汁外溢，而成谷疸。

治宜茵陈蒿汤清利湿热。方中茵陈、栀子清利湿热，导邪下出，从小便而去；大黄泄热破结，使阳明瘀滞之热，从小便排出体外。三药相配，使二便通利，湿热下行，气机复常，诸证可愈。故方后注云“尿如皂角汁状”，“黄从小便去”。

【选注】

《金匱要略心典》：“谷疸为阳明湿热瘀郁之症。阳明既郁，营卫之源壅而不利，则作寒热；健运之机窒而不用，则为不食，食入则适以助湿热而增逆满，为头眩，心胸不安而已。”

14.黄家，日晡所发热，而反恶寒，此为女劳得之。膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑，足下热，因作黑疸。其腹胀如水状，大便必黑，时溏，此女劳之病，非水也。腹满者难治。硝石矾石散主之。

硝石矾石散方

硝石 矾石烧，等分

上二味，为散，以大麦粥汁和服方寸匕，日三服。病随大小便去，

小便正黄，大便正黑，是候也。

【诠解】

本条论述女劳疸兼有瘀血的证治。阳明湿热的黄疸病，是日晡时发热，而女劳疸，日晡时则恶寒，恶寒便知非阳明热证。这是因为由于女劳伤了肾，肾与膀胱相表里，病及其合，膀胱之气不能温煦于表，故恶寒。肾虚不能气化水府津液，水停于心，故少腹满，膀胱急。少阴阴虚，故足下热，尺脉浮而盗汗。“额上黑”为肾色上出（解见第二条）。此为阴分邪热不解，使瘀血内停，故腹满如水状，瘀血在于肠，故大便黑，时溏。此为女劳疸挟有瘀血之证，是女劳疸的变证。如病至后期，脾肾两败，肾不主水，脾不运化，出现水肿腹胀满，多为预后不良，治疗亦很困难。

治宜硝石矾石散，行瘀清热治疸。方中硝石苦寒入血，软坚逐瘀，清热凉血；矾石消水湿，清热解毒；大麦厚胃益脾，消积进食，以缓硝石之烈。三药相合，共奏消瘀除热之功。

硝石矾石散是治女劳疸兼有瘀血者之要方，但也可治疗其他类型的黄疸病，如张锡纯曰：“《金匮》有硝石矾石散，原为治女劳疸之专方，愚恒借之以概治疸证皆效。”又曰：“且西人谓有因胆石成黄疸者，而硝石矾石散，又善消胆石。有因钩虫成黄疸者，而硝石矾石散，并善除钩虫。”所以，本方可治各种黄疸病。

【选注】

《金匮要略心典》：“黄家日晡所本当发热，乃不发热而反恶寒者，此为女劳肾热所致，与酒疸、谷疸不同。酒疸、谷疸热在胃，女劳疸热在肾。胃浅而肾深，热深则外反恶寒也。膀胱急，额上黑，足下热，大便黑，皆肾热之征，虽少腹满胀，有如水状，而实为肾热而气内畜，非脾湿而水不行也。惟是症兼腹满，则阳气并伤，而其治为难耳。硝石咸寒除热，矾石除痼热在骨髓，骨与肾合，用以清肾热也。大麦粥和服，恐伤胃也。”

【病案举例】

薛姓，男，32岁。去夏患黄疸性肝炎，经用清热利湿药治疗黄疸消退。病后失调导致肝区胀痛，常服舒肝理气药，疼痛稍轻。至冬再度出现黄疸，仍用中药调治。久服清热利湿退黄诸药，黄疸始终不退，有时虽退亦不尽；今春黄疸加深，经某医院检查，确诊为早期肝硬化。用西药治疗一个时期，症状未见减轻，面色灰滞而黑，巩膜黄染，食少，便溏，有时呈灰黯色，脘腹胀满，肝区胀痛不舒，有时牙龈出血。舌质右

边有紫斑，舌苔白腻。此《金匱》之女劳疸。病因湿热内蕴，熏蒸为黄疸，黄疸日久不愈，邪由气分进入血分，血瘀湿滞内郁为病。治当化瘀燥湿。仿硝石矾石散法，汤散并进，以希速效。若见腹水则不可治。

处方：明矾3克，硝石3克。研细胶囊装，分三次服，大麦粥汤送下。

另：柴胡6克，鳖甲15克（先煎），白芍10克，桃仁6克，红花6克，白术12克，茯苓、牛膝各10克，茵陈12克。

每日1剂，连服15剂，黄疸渐退，面色灰黑渐转灰滞，脘腹胁部胀痛减轻，饮食增多，瘀湿有消退之机，脾气有来复之象。原方即效，当加減继服，再进20剂，黄疸基本消退，面色灰滞，渐转红润，腹胁胀痛轻微，大便正常，食欲如常，血瘀湿滞，渐化将尽，脾气健运，病情日趋稳定，改用鳖甲煎丸与硝石矾石散常服，以善其后。嘱注意饮食起居，防病反复。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,7:2）

15.酒黄疸，心中懊_懔，或热痛，栀子大黄汤主之。

栀子大黄汤方

栀子十四枚 大黄一两 枳实五枚 豉一升

上四味，以水六升，煮取二升，分温三服。

【诠解】

本条是论述酒疸热重于湿的证治。由于饮酒过度，湿热聚于胃中，邪热内盛，上郁于心胸，气机不利，故心中懊_懔而成热痛。

治宜大黄栀子汤，清利实热。方中栀子清在上之郁热，屈曲下行，利尿渗湿；大黄泄热破结，以利腑气；豆豉清宣膈上之蕴热；枳实行气消痞。四药相须，消散郁热，清利膈脘，则诸证可解。

本证为邪热偏盛于上，既有心中懊_懔，发热疼痛，面目黄色鲜明，又有身热，烦躁不安，大便难，而小便不利等证。

栀子大黄汤的作用在于清除实热，与茵陈蒿汤作用相似，但同中有异。茵陈蒿汤证是湿热俱盛，并以腹满为主，所以方中用大黄二两，配茵陈通利湿热；栀子大黄汤证为热重于湿，且以心中懊_懔为主，因此，

方中大黄用一两，配豆豉、栀子泄热除烦。

【选注】

《医门法律》：“此治酒热内结，昏惑懊^懊之剂。然《伤寒论》中有云‘阳明病，无汗，小便不利，心中懊^懊者，身必发黄’，是则诸凡热甚于内者，皆足致此，非独酒也。”

16.诸病黄家，但利其小便，假令脉浮，当以汗解之，宜桂枝加黄芪汤主之。方见水气病中。

【诠解】

本条论黄疸有表邪的证治。黄疸的病因，多为湿热郁蒸，气化失职，湿热不去而成。治以清利湿热，通利小便，方能达到退黄目的，所以说：诸病黄家，但利其小便。治疗黄疸病，大都如此。但也有内热不盛，表虚挟湿，寒湿外束，阳气不伸，湿邪内郁，而成黄疸。常见脉浮汗出等证。当以发汗祛邪，解郁退黄为主，可用桂枝加黄芪汤治之。方中以桂枝汤解表透邪，调和营卫，舒展阳气；黄芪益卫以行表湿，合桂枝汤可为黄疸病的解表剂。桂枝加黄芪汤适用于表虚挟湿，内热不重之证。如表实而湿热内盛，则用麻黄连翘赤小豆汤为宜。

【选注】

《医宗金鉴》：“诸黄家病，谓一切黄家病也。黄病无表里证，热盛而渴者，当清之，湿盛小便不利者，但当利其小便。假令脉浮则为在表，当以汗解之，宜桂枝加黄芪汤。于此推之，可知脉沉在里，当以下解之也。”

17.诸黄，猪膏发煎主之。

猪膏发煎方

猪膏半斤 乱发如鸡子大三枚

上二味，和膏中煎之，发消药成，分再服，病从小便出。

【诠解】

本条论黄疸伤阴化燥的证治。凡湿邪郁于血分，久而生热，郁蒸气血不利，出现津枯血燥，皮肤黄而晦暗，即为阴黄，治当以猪脂润燥，发灰入血和阴，则黄色可去。

【选注】

《金匱要略心典》：“此治黄疸不湿而燥者之法。按《伤寒类要》云：男子、女人黄疸，饮食不消，胃胀，热生黄衣，在胃中有燥屎使然，猪膏煎服则愈。盖湿热经久，变为坚燥；譬如𪔐𪔐，热久则湿去而干也。《本草》：猪脂利血脉，解风热，乱发消瘀，开关格，利水道，故曰病从小便出。”

18.黄疸病，茵陈五苓散主之——一本云：茵陈汤及五苓散并主之。

茵陈五苓散方

茵陈蒿末十分 五苓散五分方见痰饮中

上二味和，先食饮方寸匕，日三服。

【诠解】

本条论述黄疸病湿重于热的证治。由于脾胃湿重热轻，湿郁热阻，上使肺气不得通调，下使膀胱津液不化，故见口渴，小便不利的津液不化之证。

治宜茵陈五苓散，行气利湿，清热退黄。方中茵陈清利湿热而退黄；五苓散化气利水，祛除湿邪。湿除热退，气机通畅，则诸证自解。

【选注】

《金匱要略编注》：“此黄疸小便闭塞，气分实证通治之方也。胃

中湿热相蒸则一，但有气血风寒之分，故后人有阴黄阳黄之别。盖胃为水谷之海，营卫之源，风入胃家气分，风湿相蒸，是为阳黄；湿热流于膀胱，气郁不化，则小便不利，当用五苓散，宣表里之邪；茵陈开郁而清湿热，则黄自退矣。”

【病案举例】

何某，女，45岁。身目俱黄，但色不甚鲜明，腹部胀满，食少纳呆，心中烦，有时恶心，呕吐，口腻不和，渴不多饮，四肢乏力，溺黄。舌质稍淡，苔黄厚腻，诊脉弦缓尚有力。肝功能：黄疸指数23单位，硫酸锌浊度25单位，谷丙转氨酶550单位。脉证合参，乃湿重于热之“阳黄”。投以茵陈五苓散加味：

茵陈20克，桂枝4克，猪苓12克，白术12克，泽泻12克，茯苓18克，栀子9克，黄柏6克，半夏9克，藿香6克，佩兰6克，枳壳6克，厚朴6克。

本方在茵陈五苓散的基础上加黄柏、栀子之苦寒以清热泄火，藿、佩、夏、朴辛通苦降，辟秽化浊。

复诊：自诉服上药八剂，证情大有好转，惟大便稍结，口干苦。复查肝功能：黄疸指数8单位，硫酸锌浊度18单位，谷丙转氨酶195单位。原方去厚朴、桂枝之辛温，加滑石15克，取其甘寒，利尿清热，续服八剂，半月后询访，病告痊愈。

（摘自《湖北中医杂志》1981,6:27）

19.黄疸，腹满，小便不利而赤，自汗出，此为表和里实，当下之，宜大黄硝石汤。

大黄硝石汤方

大黄 黄蘗 硝石各四两 栀子十五枚

上四味，以水六升，煮取二升，去滓，内硝更煮，取一升，顿服。

【论解】

本条论述黄疸病热盛里实的证治。由于湿热熏蒸脾胃，气机不畅，湿浊内壅，所以腹满。热盛湿阻，故小便不利而赤。“自汗出”为表和无病。此证为表和里实，治当泻下。

治宜大黄硝石汤清泄实热。方中大黄、硝石攻下瘀热，通便泄热；

栀子、黄柏清热燥湿，除湿退黄。诸药相配，清泄三焦实热，使湿热邪气从下泄去，故其病可愈。

本证与大黄栀子汤证，同为邪热偏胜之证。但大黄硝石汤证是里热极盛，病情比大黄栀子汤证更为严重，所以方中苦寒泻泄之力为强。因此，大黄栀子汤证为邪热偏胜之轻证，而大黄硝石汤证是邪热偏胜之重证。

【选注】

《医宗金鉴》：“李彰曰：腹满，小便不利而赤，里病也。自汗出，表和也。里病者，湿热内甚，用栀子清上焦湿热，大黄泻中焦湿热，黄柏清下焦湿热，硝石则于苦寒泻热之中，而有燥烈发散之意，使药力无所不至，而湿热悉消散矣。”

【病案举例】

郭某，男，48岁，工人。患者开始发热、恶寒、头眩恶心，继而但热不寒，惟头汗出，心下烦闷，口干渴欲饮，下腹胀满，两胁下胀拒按，大便四日未解，一身面目尽黄，光亮有泽，小便短少，如栀子汁，脉滑数有力。肝功能：黄疸指数52个，硫酸锌浊度22单位，谷丙转氨酶480单位，脉证合参，系热瘀于内，湿热熏蒸，热盛于湿之“阳黄”。遂投大黄硝石汤合茵陈蒿汤清泄胆胃湿热，更佐云苓、扁豆淡渗利湿健脾。

方用：茵陈18克，栀子18克，大黄9克，黄柏9克，芒硝9克，云苓18克，扁豆18克。

服五剂后，大便通利，小便转淡黄，腹部微胀等其他证情亦有好转。肝功能化验检查：黄疸指数7个单位，硫酸锌浊度15单位，谷丙转氨酶185单位。上方微事增损，去芒硝、大黄，加柴胡6克、胆草5克以平肝、泄热，勿使乘土，续服17剂。三诊，诸症已愈，以栀子柏皮汤合参苓白术散，清余邪而调脾胃，续服五剂善后，半月后随访，已上班工作。

（摘自《湖北中医杂志》1981,6:27）

20.黄疸病，小便色不变，欲自利，腹满而喘，不可除热，热除必哕，哕者，小半夏汤主之。方见痰饮中。

【诠解】

本条论黄疸病误治发生变证的治疗方法。由于脾气虚弱，湿多热少，湿浊内聚，脾虚不能温化，故见腹满，欲自利，小便色不变，皮表色淡黄而不枯燥。湿浊上壅，肺气不宣，则为喘逆，本证如果误用苦寒

清泻之品，则损伤胃阳，胃气不降，湿浊不行，凝为痰饮，故上逆作哕，治以小半夏汤，温散寒饮，行郁除满，降逆止哕。俟呕逆停止，再议黄疸之治。

【选注】

《金匮要略心典》：“便清自利，内无热证，则腹满非里实，喘非气盛矣；虽有疸热，亦不可以寒药攻之，热气虽除，阳气则伤，必发为哕。哕，呃逆也。魏氏谓胃肠为寒药所坠，欲升而不能者是也。小半夏温胃止哕，哕止然后温理中脏，使气盛而行健，则喘满除，黄病去，非小半夏能治疸也。”

21.诸黄，腹痛而呕者，宜柴胡汤。必小柴胡汤，方见呕吐中。

【诠解】

本条论黄疸病属肝邪犯胃的证治。由于肝旺乘脾，脾胃湿热郁结，蒸郁发热；湿热郁滞胃肠，气机不顺畅，则见腹痛；胃气上逆，则呕。

治以小柴胡汤疏肝清热，健脾和胃，调畅气机，肝脾之气得运，则湿热可去，黄疸、腹痛、呕吐可愈。

本方适用于黄疸病，见胸胁苦满，头晕目眩，脘闷欲吐等证。若加栀子、茵陈，清透半表半里之邪，治黄之效更佳。

【选注】

《金匮要略论注》：“邪高痛下，此少阳证也。是黄虽脾胃之伤，实少阳郁热，故以小柴胡汤仍去其本经之邪；但小柴胡主和解，此必黄之不甚而亦未久者也。”

【病案举例】

某男，52岁，1977年1月10日入院。患者于1972—1976年屡经胆囊造影及超声波检查，确诊为胆囊结石，但既往无剧烈绞痛及黄疸、风湿病史。1月3日起，每天恶寒发热，达38℃，并有剑突后贯穿至后背顶痛，9日开始出现右膝痛，入院后左膝、左第一跖跗关节相继红肿热痛，活动障碍，口苦咽干，尿黄如茶，舌红苔黄浊，脉弦数。体温最高达38.9℃，胆囊区轻压痛，墨菲氏征可疑。白细胞计数10400/立方毫米，中性58%。血清胆红素1.0毫克%，黄疸指数10单位。血沉58毫米/小时，抗“O”625单位。十二指肠液分析：白细胞（+），血培养无菌生长。

中医诊断：①少阳病；②热痹。西医诊断：①胆道结石并感染；②感染性中毒性关节炎。

入院后服小柴胡汤合茵陈蒿汤加减：柴胡12克，黄芩9克，法夏9克，生姜2片，大枣4枚，甘草3克，绵茵陈30克，栀子12克，川楝子12克，板蓝根24克。每日服二剂，肌注中草药清热解毒（本院自制消炎Ⅱ号和鱼腥草注射液），14日晨作十二指肠引流，当天体温降至37.3℃，次日体温降至正常，诸关节红肿热痛骤然若失，上腹痛消失，仅行走时两膝关节无力为唯一主诉，以后用四逆散加减调理数日，痊愈出院。

（摘自《新中医》1980,2:44）

22.男子黄，小便自利，当与虚劳小建中汤。方见虚劳中。

【诠解】

本条论述虚劳痿黄的证治。本证是由于脾胃虚寒，阴血亏损，阳气不足，阴虚内热，内热熏蒸，阳不温煦，气郁不畅，血不外荣，所以皮色痿黄，水湿尚能下流，故见小便自利。

治以小建中汤，调阴阳，和营卫，健运脾胃，开发生化之源，使气血充足，自能荣养肌肤，温和皮表，则痿黄之色可变。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“男子黄者，必由入内虚热而致也，反见小便自利，为中下无实热，惟虚阳浮沉为黄耳；故与治虚劳之剂补正气，正气旺则荣卫阴阳和而黄自愈矣。”

附方

瓜蒂汤

治诸黄。方见喝病中。

【诠解】

本方治黄疸湿热凝结于上，而有上逆作呕之证。用瓜蒂汤因势利导，吐而去黄之法。据临床报道：“各地对瓜蒂治疗急慢性肝炎、黄疸进行了一些临床观察。如第三军医大学报道用瓜蒂内服治疗60例慢迁肝，不仅能改善症状，缩小肝脾肿大，而且退黄降酶效果好，对蛋白系统也有一定改善，获得较满意的近期疗效。湖南医学工业研究所对瓜蒂的抗肝炎有效成分进行了提取和分析……葫芦素BE的粗制剂治疗慢肝，显效率46.6%，远期疗效亦较好，未见明显副作用。但民间直接服用甜瓜蒂过量（最多达182个），引起严重中毒，大量呕吐，腹痛，腹

泻，甚至神志不清，中毒死亡的报道已有数起，应引起重视，尤其不可空腹服用。”

（摘自《上海中医药杂志》1982,3:24）

必须注意，瓜蒂有毒，升举阳气，实证体强者可用。血虚肝旺者忌用，量宜小不宜大。

【选注】

《金匱要略心典》：“案《删繁》方云：服讫，吐出黄汁，亦治脉浮欲吐者之法也。”

《千金》麻黄醇酒汤

治黄疸。

麻黄三两

上一味，以美清酒五升，煮取二升半，顿服尽。冬月用酒，春月用水煮之。

【诠解】

本方治疗湿邪郁于肌肤，卫阳闭阻，表实无汗，热郁于内，而发黄疸。麻黄醇酒汤发散表湿，开郁散热。方中麻黄辛温发汗，亦能利水，使湿热从汗而散，从下而去。醇酒温散，可助麻黄发汗，通行营卫。二药相须，使湿热可去，营卫可通，黄疸则愈。

【选注】

《金匱方歌括》：“麻黄轻清走表，乃气分之药，主无汗表实证。黄疸病不离湿热之邪，用麻黄醇酒汤者，以黄在肌表营卫之间，非麻黄不能走肌表，非美酒不能通营卫，故用酒煮，以助麻黄发汗，汗出则营卫通而内蕴之邪悉从外解耳。”

结语

本篇比较全面地论述了黄疸病。并将黄疸病分成谷疸、酒疸、女劳疸三种类型，而湿热黄疸为本篇论述的重点。谷疸证候以食即头眩，心

胸不安，脉迟，食难用饱，饱则烦眩等证为主；酒疸证候以心中懊^怵，热痛，足下热为主；女劳疸的证候，可见日晡发热而反恶寒，膀胱急，小便自利，额上黑，足下热，大便必黑，时溏。此外，凡因湿热所致的黄疸均有小便不利，而女劳疸与虚劳发黄则小便自利为异。

黄疸病的治疗，无论是谷疸、酒疸、女劳疸，首先要辨证清楚，治方无误。如谷疸、酒疸要分清湿胜于热，热胜于湿或湿热俱盛的等病情。如湿重者，可用茵陈五苓散，利水渗湿，清热退黄；热重者，可用栀子大黄汤，清利实热，或用大黄硝石汤，清泄实热；湿热俱盛者，可用茵陈蒿汤，清热利湿，通利气机。女劳疸，若兼有瘀血者，则宜硝石矾石散，除浊散瘀。黄疸如脉浮表虚而自汗出者，可用桂枝加黄芪汤；表实无汗者，可用麻黄醇酒汤。黄疸兼有呕逆者，宜用小半夏汤；兼有腹痛呕吐者，可用小柴胡汤。如病邪在上者，宜用吐法，可酌情选用瓜蒂汤。因寒湿发黄者，宜用温中化湿法。痿黄病大肠燥结者，宜用猪膏发煎。虚劳痿黄者，应以小建中汤治之。辨证得法，则效如桴鼓。

惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六

概说

本篇是论述惊、悸、吐、衄、下血和瘀血等病的辨证论治。至于胸满一证也是瘀血为病的一种反映，故可相提并论。篇中共有条文十七条，载方五首。其中第一条是论惊悸的病机和脉诊，第十二、十三则论惊悸的辨证论治和方药。从第二条至第九条是论吐、衄、下血的脉证、鉴别、转归和治疗禁忌。第十条、十一条是论瘀血的脉证和治法。第十四条至第十七条是论吐、衄、下血的证治和方药，由于惊、悸，吐、衄、下血的病机皆与心和血有关，故合为一篇论述。

惊，是惊怖，是触然临之而神志受惊的一种病证；悸是心内动，筑筑惕惕而不能自主的一种症状。至于非外界刺激而内生的惊、悸，皆因气血虚弱不能养心，或痰热扰心之所致，两证往往同时存在，故统称之为惊悸证。

吐、衄、下血和瘀血，都是血液之病，从病因讲有寒热虚实之分；从病位论有或上，或中，或下之别，故其治法也应随证而异。

1.寸口脉动而弱，动即为惊，弱则为悸。

【诠解】

本条是从脉象论述惊悸的病机。人之心气素虚，则心神内怯，猝遇非常之变，使气乱神荡，因而血气逆乱，则使寸口之脉动乱失序，而发生恐惧惊骇，故曰“动则为惊”。如果气血两亏，则心失所养，而见心悸不安，其脉弱而无力，故曰“弱则为悸”。

惊与悸虽是两证，有外触而发，自内而生之分，从实质上讲，惊与悸都是因于气血虚衰所致，不过有轻重之不同而已。并且，受惊以后亦可发生心悸，心悸时亦可发生惊恐。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“心者君主之官，神明出焉，不役形，不劳心，则精气全而神明安其宅；苟有所伤，则气虚而脉动。动则心悸神惕；精虚则脉弱，弱则怔忡恐悸。盖惊自外物触入而动属阳，阳变则脉动；悸自内恐而生属阴，阴耗则脉弱。是病宜和平之剂，补其精气，镇其神灵，尤当处之以静也。”

2.师曰：尺脉浮，目睛晕黄，衄未止，晕黄去，目睛慧了，知衄今止。

【词解】

目睛晕黄：具有两义，一为病人目睛之色晕黄不亮，二为目睛视物晕黄不明。

目睛慧了：指由目睛晕黄变为目睛视物清晰。

【诠解】

本条是论述衄血证的预后。尺脉以候肾。由于肾阴虚，虚火浮动，故尺脉浮。由此推断，若因肝热上蒸于目，则目睛晕黄。似此虚火上炎，迫血妄行，可发生衄血之证。若衄后而晕黄不去，则热未尽出，故知衄仍未止。反之，若晕黄去，目睛视物慧了的，则知肝肾虚火已敛，阴气以升，故知衄今止。

【选注】

《金匱要略心典》：“尺脉浮，知肾有游火；目睛晕黄，知肝有蓄热，衄病得此，则未欲止。盖血为阴类，为肝肾之火热所逼而不守也。若晕黄去，目睛且慧了，知不独肝热除，肾热亦除矣，故其衄今当止。”

3.又曰：从春至夏衄者太阳，从秋至冬衄者阳明。

【诠解】

本条是从季节气候的变易论述衄血的辨证。手足太阳与手足阳明四经的经脉，皆循行鼻位，故鼻衄与此四经有关系。从春至夏，阳气升起，应发布于外。若外感风寒，客于肌表，阳气不能外达，郁而不伸，积于营分，则迫血上逆而衄血，故曰“从春至夏衄者太阳”，以太阳主表故也；从秋至冬，阳气沉降，气应内收，如阴虚内热，内热上炎，迫血上逆而致衄，故曰“从秋至冬者阳明”，以阳明主里故也。总之，春夏衄血，多属外感病；秋冬衄血，多属内伤病。由此可知，春夏衄血多因外感风寒所致，秋冬衄血多由阴虚内热引起。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“《内经》太阳为开，阳明为合，春夏气主生发，以开者应之，故邪气逼血从升发冲出；秋冬收藏，以合者应之，故邪郁内极而后发出。衄为阳盛，独不言少阳，以太阳阳明二经，皆上交额中故也。”

4.衄家不可汗，汗出必额上陷，脉紧急，直视不能眴，不得眠。

【词解】

额上陷：额上肌肉塌陷不起。

眴：音舜。形容眼珠转动。

【诠解】

本条是论述衄家误汗后的症状。衄家长期失血，若再发汗，既亡其阴，又伤其阳。阴阳两伤，则血脉空虚，故见额上塌陷；气血虚少，血脉不荣，则失去柔和之象，故血脉紧急；掣引目睛不和，故两目直视而不能眴；汗为血液，血虚则不能养心潜阳，以致阳气不敛，故烦躁而不得眠。

【选注】

《金匱要略心典》：“血与汗皆阴也，衄家复汗，则阴重伤矣。脉者血之府，额上陷者，额上两旁之动脉，因血脱于上而陷下不起也。脉紧急者，寸口之脉，血不荣而失其柔，如木无液而枝乃劲也。直视不眴不眠者，阴气亡则阳独胜也。经云：夺血者无汗，此之谓夫。”

5.病人面无血色，无寒热，脉沉弦者衄；浮弱，手按之绝者，下血；烦咳者，必吐血。

【诠解】

本条是论述内伤出血的几种脉证。“面无血色，无寒热”是本条总纲，概括衄血、下血、吐血等证候而言的。“面无血色”是失血之后，血虚不能上荣，以致面色**晄**白。“无寒热”是说没有恶寒发热的表证。衄血、下血、吐血三种失血证，病机不同，脉象亦有所不同。病人脉见沉弦，沉以候肾，弦为肝脉，由于肾虚不能涵养肝木，肝旺气升，血从上逆，则为衄血；如脉见浮弱而按之绝者，夫浮为阳虚，弱为血虚，按之绝而不起，则主虚阳上浮，不能固摄下焦阴血之象，所以出现下血之证。如不见下血，而烦咳为甚者，是虚火扰动心肺，则必致吐血。

【选注】

《金匱要略直解》：“病人面无血色，脱血之象也。《上经》曰：男子脉虚沉弦，无寒热，时目瞑兼衄。今无寒热，而脉弦衄者，则与上证不殊，为劳证也。若脉浮弱，手按之绝者，有阳无阴也，故知下血。烦咳者，病属上焦也，故知吐血。”

6.夫吐血，咳逆上气，其脉数而有热，不得卧者死。

【论解】

本条是论述吐血、咳血等血证的预后诊断。由于阴虚火旺，迫血妄行，故吐血。吐血之后，阴血耗损，阳气独盛，故脉数而有热；虚热熏灼肺金，肺津枯竭，故咳逆上气；阳盛于上，不入于阴，故心烦不得卧。在吐血之后，出现脉数身热，咳逆上气，不得卧等证，是阴血更虚，而阳热更旺的反应。如此，吐血之后则阴血更虚，阳热之邪而越旺，形成阴越虚而阳越亢的恶性因果，其预后则一定是险恶的，故曰“死”。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉数、身热，阳独胜也；吐血、咳逆上气，不得卧，阴之烁也。以既烁之阴，而从独胜之阳，有不尽不已之势，故死。”

7.夫酒客咳者，必致吐血，此因极饮过度所致也。

【论解】

本条是论述酒客吐血的病机。酒客致咳，热伤肺也。肺被热伤，气不宜降，故咳逆也；久咳不已，必动血甚，故曰“必致吐血”，应禁酒，清肺热则愈。故又曰：“此因极饮过度所致也。”

【选注】

《金匱要略论注》：“此言吐血不必尽由于气不摄血，亦不必尽由于阴虚火盛，其有酒客而致咳，则肺伤已极，又为咳所击动，必致吐血，此非内因也，故曰极饮过度所致，则治之者，当以清酒热为主可知。”

8.寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相击，此名曰革，妇人则半产漏下，男子则亡血。

【论解】

本条是论述虚寒失血的脉象。本条已见于《血痹虚劳篇》。脉弦为阳气不足，阳气不足故曰“减”；脉大中空为阴血不足，阴血不足故曰“芤”。如此弦芤相合则脉革，革则主阴阳气血皆不足，必然导致阳虚

不能固，阴虚不能守，从而引起女子半产漏下与男子亡血失精等病变。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“成无己谓减为寒者，谓阳气少也。芤为虚者，谓阴血少也。所谓革者，既寒且虚，则气虚血乖，不循常度，男子得之为真阳衰而不能内固，故主亡血。女子得之为阴血虚，而不能滋养，故半产漏下。此条出第二卷妇人证有旋覆花汤。”

9.亡血不可发其表，汗出则寒栗而振。

【词解】

栗：心里冷叫栗。

振：动也，指身体摇动。

【诠解】

本条是论述亡血误汗的变证。本条见于《伤寒论·太阳篇》。亡血者，血已亡失，若再发汗，则又复伤阳气，阳气虚则恶寒而心栗；全身振振动，如同发颤。

【选注】

《金匱要略心典》：“亡血者，亡其阴也；更发其表，则阳亦伤矣。阳伤者外不固，故寒栗；阴亡者内不守，故振振动摇。前衄血复汗，为竭其阴；此则并亡其阳，皆所谓粗工嘻嘻者也。”

10.病人胸满，唇痿，舌青，口燥，但欲漱水，不欲咽，无寒热，脉微大来迟，腹不满，其人言我满，为有瘀血。

【词解】

唇痿：痿，同萎，指口唇不华枯萎。

【诠解】

本条是论述瘀血的脉证。瘀血留滞，气机不畅，新血不生，血不外荣，故唇痿；瘀血之色见于舌，故舌青；瘀血停留，气不化津，不能上润，故口燥，但欲漱水，不欲咽。由于瘀血壅滞在下，气塞于上，则脉微大，胸满；瘀血内结于腹部深处，血行不畅，涩而不利，故脉来迟。由于瘀血结于腹部深处，所以望之腹虽不满，但病人却感觉胀满。“脉微大来迟”，实质是指脉象虽大，但脉势不足，故往来涩滞不利。

【选注】

《医宗金鉴》：“今病人无寒热他病，惟胸满、唇痿、舌青、口

燥、漱水不欲咽，乃瘀血之胸满也。唇、舌，血华之处也，血病不荣，故痿瘁色变也。热在血分，故口燥漱口不欲咽也。脉微大来迟，阴凝之诊，则当腹满，今腹不满，询之其人，言我满在胸不在腹也，与上如是之证推之，为有瘀血也。”

11.病者如热状，烦满，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴伏，是瘀血也，当下之。

【诠解】

本条是论述瘀血当下之证。本证因瘀血不化，瘀郁化热，故病者如热状。由于热伏阴分，气机不畅，则烦满；瘀血不行，郁热伤阴，津少不润，则口干燥而渴。因本证是瘀血化热，内伏阴分，故其脉反无热。此为阴伏，是瘀血也，当用下法，宜桃核承气汤，抵当丸之类。

【选注】

《医宗金鉴》：“此承上文互详证脉，以明其治也。如热状，即所谓心烦胸满，口干燥渴之热证也；其人当得数大之阳脉，今反见沉伏之阴脉，是为热伏于阴，乃瘀血也。血瘀者当下之，宜桃核承气，抵当汤、丸之类也。”

12.火邪者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。

桂枝救逆汤方

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 生姜三两 牡蛎五两，熬 龙骨四两 大枣十二枚 蜀漆三两，洗去腥

上为末，以水一斗二升，先煮蜀漆，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

【词解】

火邪：是指因火劫，如用瓦熨、烧针发汗之法。

【诠解】

本条是论火劫致惊的治法。本证为太阳伤寒，医以火法迫劫出汗，以致损伤心阳，阳气不化津液成痰，迷于心宫，故见烦躁、惊悸不安等证。

本证为心阳虚而痰浊内阻，治宜桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆

汤，敛阳镇惊，祛痰安神。方中桂枝、甘草扶助心阳；生姜、大枣调和营卫；蜀漆除痰化饮；牡蛎、龙骨收敛神气，安神定志，以治惊狂。诸药相合，使心阳奋起，痰浊消除，则惊止而神安。

【选注】

《金匱要略论注》：“此方治惊，乃治病中之惊狂不安者，非如安神丸、镇惊丸等之镇心为言也……故标之为火邪者，见胸中者清阳之所居，乃火劫亡阳，致神明散乱，故以桂、甘、姜、枣宣其上焦之元阳，则燭火自熄；惊则必有瘀结，故加蜀漆破血，疗胸中结邪；而以龙骨之甘涩平，牡蛎之酸咸寒，一阳一阴以交其心肾，而宁其散乱之神。若桂枝汤去芍药，病不在肝脾，故嫌其酸收入腹也。”

13.心下悸者，半夏麻黄丸主之。

半夏麻黄丸方

半夏 麻黄等分

上二味，末之，炼蜜和丸小豆大，饮服三丸，日三服。

【诠解】

本条是论述寒饮心悸的证治。本病因脾不健运，寒饮内停心下，水气上凌于心，故心下动悸。同时又可有上闭肺气，中停胃中的喘息短气、头晕目眩、呕吐、心下痞等证。

治宜半夏麻黄丸，一宣一降，以蠲饮邪。方中用麻黄宣通肺气，以散水邪；半夏和胃降逆，以蠲寒饮，俾阳气通，饮邪除则心悸可愈。然伏邪为有形之邪，必须抚剿兼施，以使缓缓而去，若操之过急，未有不伤正气者，故以小量丸剂为宜。

痰饮心悸，一般多用桂枝、茯苓通阳利水。本病为寒饮内盛，阳气闭郁之证，故以半夏麻黄丸宣阳蠲饮。由此可知，悸证不只是气血亏损引起，其中也有寒饮之为患。

【选注】

《金匱要略心典》：“此治饮气抑其阳气者之法。半夏蠲饮气，麻黄发阳气，妙在作丸与服，缓以图之，则麻黄之辛甘，不能发越津气，而但升引阳气；即半夏之苦辛，亦不特蠲除饮气，而并和养中气，非仲景神明善变者，其孰能与此哉。”

14.吐血不止者，柏叶汤主之。

柏叶汤方

柏叶 干姜各三两 艾三把

上三味，以水五升，取马通汁一升合煮，取一升，分温再服。

【词解】

马通汁：即马溺，以白马者为良。

【诠解】

本条是论述吐血不止的证治。本证是因中气虚寒，气不摄血，血不归经而致上溢吐血。“吐血不止”这句话，是指吐血时多时少，时吐时停，持久不止，顽固不愈之意。

治宜柏叶汤，温经止血。方中柏叶止血，其性清肃而降，以制血之上逆；干姜、艾叶温中，暖气以摄血；马通汁育阴止血，能引血下行，且监干姜、艾叶之燥。四药共奏温中摄血止呕的功效。临床上如无马通汁，亦可用童便代替。

【选注】

《金匱要略论注》：“吐血本由阳虚，不能导血归经，然血亡而阴亏，故以柏叶之最养阴者为君，艾叶走经为臣，而以干姜温胃为佐，马通导火使下为使，愚意无马通，童便亦得。”

【病案举例】

刘某，男，42岁。素有高血压史，经常头痛失眠。一日忽鼻衄频频量多，色鲜红，急送往某医院五官科治疗，血暂止。回家后又流血不已，延余诊治。症见：头胀目眩，舌紫苔略黄燥，脉弦。此系肝阳上亢，迫血妄行所致，宜滋阴凉血止血，急以自拟方生地侧柏叶汤加童便：生地30克，侧柏叶9克，炙艾叶6克，麦冬9克，杭芍9克，藕节5个，炮姜炭9克，炙甘草6克。加童便为引服一剂，衄血减少，再剂全止。

（摘自《云南中医杂志》1980,1:13）

15.下血，先便后血，此远血也，黄土汤主之。

黄土汤方亦主吐血、衄血

甘草 干地黄 白术 附子炮 阿胶 黄芩各三两 灶中黄土半斤
上七味，以水八升，煮取三升，分温二服。

【词解】

远血：先大便，后出血，血来自直肠以上的部位，离肛门较远，称为远血。

【诠解】

本条是论述虚寒下血的证治。本证是因中气虚寒，脾阳不运，气不摄血而成便血。大便下行，气亦下泄，血随之而下，故为先便后血之远血证。中气虚寒，气血来源不足，则面色**晄**白，恶寒倦怠，腹痛喜按，舌淡脉弱等证，自在言外。

治宜黄土汤，温脾扶阳，补血摄阴。方中灶中黄土，一名伏龙肝，配白术、附子、甘草温中祛寒，健脾统血；阿胶、生地养血止血；黄芩清热凉血坚阴，防止温药动血。诸药相合，振奋脾阳，统血循行脉中，则便血自止。

黄土汤与柏叶汤同为中气虚寒不能摄阴的出血证，但病有轻重的不同。柏叶汤证，虚寒较轻，虽出血不止，但未伤正气，仅用干姜温暖中阳即可；而黄土汤证为虚寒较重的出血证，故用附子扶阳以摄阴。

【选注】

《金匱要略心典》：“下血先便后血者，由脾虚气寒，失其统御之权，而血为之不守也。脾去肛门远，故曰远血。黄土温燥入脾，合白术、附子以复健行之气；阿胶、生地黄、甘草以益脱竭之血；而又虑辛温之品转为血病之厉，故又以黄芩之苦寒，防其太过，所谓有制之师也。”

【病案举例】

赵某，女。婚后初孕，患早期流产出血不止，索方求治，书加味黄土汤予以数剂而愈，后生一女。二孕又显流产先兆，又服前方数剂得保无恙，两女均甚健。

处方：熟地黄60克，元肉30克，当归12克，黄芪18克，白术9克，附子9克，甘草9克，黄芩9克，鹿角胶30克，伏龙肝12克。

以上十味，以水十二杯，先煮伏龙肝，取八杯去渣，再煎前八味取二杯，去渣入鹿角胶，再上火候胶化尽，分二次服。

（摘自《赵锡武治疗经验》第93页）

16.下血，先血后便，此近血也，赤小豆当归散主之。方见狐惑中。

【词解】

近血：先血后便，血来自直肠的部位，离肛门较近，称为近血。

【诠解】

本条是论湿热蕴结迫血下行的证治。由于湿热蕴结于大肠，迫血下行，故为先血后便之近血证。出血时，多带脓液，后世亦称脏毒。由于湿热蕴结于中，故大便不畅，而舌苔黄腻，脉弦数等证，亦势必然矣。

治以赤小豆当归散，清利湿热，排脓消肿，活血行瘀，使热除湿祛，下血之证可自止。

【选注】

《金匱要略心典》：“下血先血后便者，由大肠伤于湿热，而血渗于下也。大肠于肛门近，故曰近血。赤小豆能行水湿，解热毒，当归引血归经，且举血中陷下之气也。”

17.心气不足，吐血、衄血，泻心汤主之。

泻心汤方亦治霍乱

大黄二两 黄连 黄芩各一两

上三味，以水三升，煮取一升，顿服之。

【词解】

心气不足：这里是指心阴不足。

【诠解】

本条是论述热盛失血的证治。由于心阴不足，心火亢盛，迫血妄行而上溢，故见吐血、衄血。邪热亢盛，故有心烦不安，面赤舌红，烦渴便秘，脉数等证。

治以泻心汤，清热泻火。方中黄芩、黄连清热降火，泻心经热，心血自宁；大黄苦泻，引血下行，使气火下降，则血静而不妄行。此即前

人所说“泻心即泻火，泻火即止血”之意。

【选注】

《金匱要略心典》：“心气不足者，心中之阴气不足也。阴不足则阳独盛，血为热迫，而妄行不止矣。大黄、黄连、黄芩泻其心之热而血自宁。”

【病案举例】

张某，男，35岁。患鼻衄不止，症见：心烦，口渴饮冷，精神不衰，舌质红，苔黄腻，脉滑数。患者平素嗜酒成癖。四诊合参，证属肺胃火郁，治当清肺火，解郁热，投以仲景大黄黄连泻心汤。方用：大黄9克，黄连6克，黄芩9克。用开水浸泡，取汁分三次服。衄止则停服。上方服一剂，鼻衄即止。

（摘自《云南中医杂志》1980,1:13）

结语

本篇论述了惊与悸的病情，举出了治疗之法：如桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨汤，而有通阳镇惊、祛痰安神的作用，以治火邪之惊狂；半夏麻黄丸，则有宣阳蠲饮的效果，以治疗寒饮凌心之悸。

在失血证中：有柏叶汤温经止血，而治吐血不止；黄土汤温脾摄血，可治远血；赤小豆当归散清利湿热，可治远血；泻心汤清热泻火，治心阴不足的吐衄。本篇同时亦论述了吐衄、便血的禁忌和预后，以及瘀血的脉证特点。总的来说，治血虽仅有四方，但对血证的病因、病机以及辨证论治的方法，已全面加以论述，并且写得很有层次，便于掌握。

呕吐哕下利病脉证治第十七

概说

本篇是论述呕吐、哕、下利等病的辨证论治。呕为有声有物，吐为有物无声，哕为无物有声，又称呃逆。呕吐门中还包括了“胃反”，胃反为幽门不开，食入反出之病。下利则包括了泄泻等疾患。

本篇共有条文四十七条，载方二十二首，附方一首。在本篇中，从第一条至第七条是论呕吐病的脉证、发病机理、病理变化，以及在治疗上的禁忌，而为本篇呕吐病的总论。第八条至二十一条是论呕吐病的辨证和治法；第二十二、二十三条是论哕证的证治和方药；第二十四条至三十五条是论下利的病理机制和下利的治疗原则，以及下利病的转归；第三十六至四十七条是论下利的辨证和治疗。呕、吐、哕、下利的病证，虽有寒热虚实之不同，并涉及肝肾等脏，但总以脾、胃、大肠、小肠的症状为主，故合为一篇论述。

呕、吐、哕、下利如果属于实证、热证的，则病多在胃肠；属于虚证、寒证的，则病多在脾胃。

1.夫呕家有痈脓，不可治呕，脓尽自愈。

【诠解】

本条是论痈脓呕吐的治法。热毒聚于胃腑，腐肉化脓，胃气上逆，驱脓外出，故见呕吐痈脓。本证呕是病之标，痈脓是病之本。治病必求其本，故应治其痈脓，使胃中热毒消散，不再化脓，有脓吐出，胃气则安，呕亦可止。如果用止呕药治呕，则热毒不解，脓液内留，病情更加恶化，所以说“不可治呕”。

呕吐的病因很多，要进行辨证论治，应求其治呕的原则。所以，第一条就提出痈脓呕吐，不治呕之标，应治痈脓的根本，可为一锤定音之论。

【选注】

《医宗金鉴》：“呕家，呕吐或谷、或水、或痰涎、或冷沫，今呕而有脓，此内有痈，脓溃而呕，非呕病也，故曰：不可治呕，脓尽自愈。”

2.先呕却渴者，此为欲解；先渴却呕者，为水停心下，此属饮家；呕家本渴，今反不渴者，以心下有支饮故也，此属支饮。

【词解】

却：有以后和“却又”的语气。

【诠解】

本条是论停饮呕吐的辨证。水湿停于胃中，胃气上逆，饮邪亦随之而出。若饮去而胃阳复，则口中渴，故知此为欲解。若水饮停于胃中，中焦气化不利，津液不能上承，故亦口渴。但渴而多饮，更助水邪，以致水饮上逆而作呕，故属于饮家。呕家因吐而伤津液，本应口渴，今反不渴者，此乃饮邪停于心下，属于饮邪的呕吐，则为病微而非邪解之比，故曰“此属支饮”。

【选注】

《金匱要略心典》：“呕家必有停痰宿水，先呕却渴者，痰水已去，而胃阳将复也，故曰此为欲解。先渴却呕者，因热饮水过多，热虽解而饮旋积也，此呕因积所致，故曰此属饮家。呕家本渴，水从呕去故也；今反不渴者，以宿有支饮在心下，愈动而愈出也，故曰此属支饮。”

3.问曰：病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者何也？师曰：以发其汗，令阳微膈气虚，脉乃数，数为客热，不能消谷，胃中虚冷故也。

脉弦者虚也，胃气无余，朝食暮吐，变为胃反；寒在于上，医反下之，今脉反弦，故名曰虚。

【词解】

引食：进食。

客热：指假热而言。

【诠解】

本条是论述胃反的病因病机。病人脉数，数为热。胃热，当消谷引食为是。今不但不消谷，而反吐，原因是因医生误用辛温发汗之品，损伤胃阳，以致胃中虚冷，其脉必数而无力。这种数脉并非实热或寒实，

不能传化水谷而引起的呕吐。因胃虚寒而胃气踴跶不安，故脉数为“客热”。

脉弦主寒，而曰虚者，是因胸膈阳虚在先，而后寒生也。又误用苦寒之品，损伤阳气，以致胃气虚寒更重。阳气不足，不能腐熟水谷，随同寒气上逆，故见朝食暮吐之证，名曰“胃反”。这种误下伤中，虚寒上逆的弦脉，与《痰饮篇》中“脉双弦者寒也，皆大下后喜虚”之意相同。

本条是论误用汗下损伤中阳，引起胃反呕吐等证，说明胃中虚寒是构成胃反证的主要病因。食入经久始出，为阳气大虚所致，即使见数脉、弦脉，也为本虚，而不得误认为它证。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉数为热，乃不能消谷，引饮而反吐者，以发汗过多，阳微膈虚所致，则其数为客热上浮之数，而非胃实气热之数矣；客热，如客之寄，不久即散，故不能消谷也。脉弦为寒，乃不曰寒而曰虚者，以寒在于上而医反下之所致，故其弦非阴寒外加之弦，而为胃虚生寒之弦矣；胃虚且寒，阳气无余，则朝食暮吐，而变为胃反也。读此知数脉、弦脉，均有虚候；曰热、曰寒，盖浅之乎言脉者耳。”

4.寸口脉微而数，微则无气，无气则荣虚，荣虚则血不足，血不足则胸中冷。

【词解】

胸中冷：是指上焦和胃气的虚冷。

【诠解】

本条是论荣虚血不足，胸中冷的辨证。由于阳气虚弱，故脉微。微则气弱而使营虚，营为血之源，荣虚则血不足，营血虚弱，则大气积于胸中者亦必虚冷，为此，则引起朝食暮吐的胃反证。

本条所论是因胸中冷导致了胃反证。同样，因胃反引起气血来源不足，亦可导致营卫气血俱虚，胸中冷的病证。因此，两者可以互相影响，形成恶性循环，使病情更加严重。

【选注】

《金匱要略心典》：“此因数为客热，而推言脉微而数者，为无气而非有热也。气者营之主，故无气则营虚；营者血之源，故营虚则血不足；营卫俱虚，则胸中之积而为宗气者少矣，故胸中冷。”

5.趺阳脉浮而涩，浮则为虚，涩则伤脾，脾伤则不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名曰胃反。脉紧而涩，其病难治。

【诠解】

本条是论述胃反证的病机。由于胃阳虚弱，饮食不化，胃气上逆，故脉浮，因此说“浮则为虚”。脾阴损伤，不能运化精微，故脉涩，所以又说“涩则伤脾”。脾胃阴阳两虚，运化功能失常，饮食之后，留于胃腑，不得消磨，宿谷不化，故朝食暮吐，暮食朝吐。

紧脉主寒盛，涩脉为阴血亏损，故脉紧而涩，则寒凝津涩，胃寒不能消谷，则呕吐不纳，脾运不能润泽，则粪干如羊屎。气血虚少，不润肌肤，则羸瘦。本证温阳则伤阴，补阴则损阳，服药则呕吐，故曰“其病难治”。

【选注】

《金匱悬解》：“趺阳者，阳明胃气之所变现也。阳明胃气，以下行为顺，脉不应见浮紧，浮则胃气之虚而不降也。胃虚而上逆，则脾虚而下陷，陷则脾伤，脾伤不能磨化水谷，故朝食而暮吐。宿谷不化，名曰胃反。胃反者，饮食倒上，是反顺而为逆也；紧涩者，血寒而阳陷也。脾败不磨而脉见紧涩，水冰地坼，微阳沦败，陷而不升，故为难治。”

6.病人欲吐者，不可下之。

【诠解】

本条是论呕吐的治疗禁忌。病人欲吐，是由于病邪在上，正气有驱邪外出之势。治宜因势利导，顺其病机，而去邪气。若计不出此，而用下法，则逆其病势，反使邪气内陷，加重病情，故曰“不可下之”。

【选注】

《金匱要略心典》：“病人欲吐者，邪在上而气方逆；若遽下之，病气必与药气相争，而正气乃蒙其祸矣。否则，里虚邪入，病气转深，或痞或利，未可知也，故曰不可下之。”

7.哕而腹满，视其前后，知何部不利，利之即愈。

【诠解】

本条是论述哕的辨证论治。哕而腹满者，是由于病阻于下而气逆于上，故腹满为本，呕逆为标。辨证当视大小便何部不利。如大便不通，糟粕内积，胃肠实热，故腹满；浊气上逆，则见呕逆。治法当通其大便，使胃气下降，呕逆则愈，可用调胃承气汤。若小便不利，水湿停聚于内，故腹满；湿浊上逆，故又见呕逆。治法当利其小便，使浊气下降，呕逆自解，可用猪苓汤治之。以上二证均指实证而言。如病到后

期，因脾胃衰败，胃气将绝而呃逆，属危重证候，应加注意。

【选注】

《金匱要略心典》：“哕而腹满者，病在下而气溢于上也，与病人欲吐者不同，故当视其前后二阴，知何部不利而利之，则病从下出，而气不上逆，腹满与哕俱去矣。”

8.呕而胸满者，茱萸汤主之。

茱萸汤方

吴茱萸一升 人参三两 生姜六两 大枣十二枚

上四味，以水五升，煮取三升，温服七合，日三服。

【诠解】

本条是论述胃寒凝聚呕吐的证治。由于胃阳不足，寒饮凝聚，阴浊散漫于胸间，故胸满。胃气上逆，则呕。

治宜吴茱萸汤，温寒止呕。方中吴茱萸、生姜化浊降逆，温阳散寒；人参、大枣温补中阳。诸药相合，可助阳散寒，温中止呕。

【选注】

《医宗金鉴》：“呕逆之气上冲于胸，胸中气实，则不受邪，必不满也；若胸中气虚，客寒邪气得以留连，故胸满也。主之吴茱萸汤，补正气，降邪气也。”

【病案举例】

患儿田某，男，2个月。于生后即见呕吐，多在进乳或饮水后约4~5分钟即喷吐而出，吐物清淡无臭，延50余天呕吐未止，在某医院诊为“幽门痉挛”。予解痉镇吐剂治疗无效。诊见患儿面色暗晦，精神委顿，形体瘦弱，哭声低微。检查：心肺无异常，腹胀而软，可见逆蠕动波形，舌淡苔白，指纹淡红。证属脾胃虚寒，浊阴上逆，治拟温胃降逆止呕。

处方：茱萸、党参各0.6克，生姜1.2克，大枣1枚，黄连0.3克。水煎至50毫升，分次频服。

服药二剂，呕吐减轻，继进二剂吐止，食欲转佳，又予二剂以巩固疗效。

（摘自《新医药杂志》1979,2:48）

9.干呕，吐涎沫，头痛者，茱萸汤主之。方见上。

【诠解】

本条是论干呕头痛的证治。由于脾胃虚寒，不能升清降浊，寒饮停滞，壅塞胸中，湿浊之气上逆则干呕、吐涎沫；胸中寒浊壅塞，清阳不升，浊阴上冒，故头痛。还可见到胸满，心下痞，舌苔白腻，脉弦滑等证。治以吴茱萸汤温中散寒，降逆止呕定痛。

【选注】

《金匱要略心典》：“干呕、吐涎沫，上焦有寒也；头者诸阳之会，为阴寒之邪上逆而痛，故治宜吴茱萸汤，以散阴气而益阳气。”

【病案举例1】

黄某，男，50岁，于1978年8月1日初诊。偏头痛反复发作十年余，痛发时或左或右，而以右侧为多。呈持续性抽痛，阵发性加剧，剧痛时每延及头巅及项部。每月发作2~3次，持续数小时或数天，伴恶心呕吐、耳鸣、食欲不振。近十来天发作加剧，经服利眠宁、颅痛定、烟酸等药未效。症见：形体瘦弱，神倦乏力，懒言，血压120/80毫米汞柱，舌淡嫩，苔微黄，脉细数。此属厥阴头痛。实由寒滞肝脉，惟寒邪久郁，渐趋化热。治宜温肝散寒，降逆止呕，佐以清热解肌。

药用：吴茱萸15克，党参30克，大枣15克，生姜30克，黄连10克，葛根30克，菊花12克。

服三剂后，诸症顿减，原法调理而愈。

（摘自《新中医》1981,8:16）

【病案举例2】

伍某之妻，患胃痛吐水，心中烦躁，久治不愈，切其脉弦，按之无力。舌质淡嫩，苔则水滑。

辨证：胃气虚寒，挟水上犯，阴来搏阳，阳与阴争，故而烦躁。

治宜吴茱萸汤。

处方：吴茱萸10克，生姜15克，党参12克，大枣12枚。

服三剂后，胃痛与吐水均减，烦躁未发。

（刘渡舟治验）

10.呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之。

半夏泻心汤方

半夏半斤，洗 黄芩 干姜 人参各三两 黄连一两 大枣十二枚 甘草三两，炙

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煮取三升，温服一升，日三服。

【诠解】

本条论述寒热错杂的呕吐与心下痞的辨证论治。由于脾胃气虚，升降失序，痰饮内停，塞于中焦，故心下痞；中气痞塞，痰邪上逆则作呕吐；水气下行则肠鸣漉漉有声。本证为上热下寒，中焦痞塞，寒热错杂的呕吐痞证。

治以半夏泻心汤，辛开苦降，扶正祛邪。方中半夏、干姜辛开温散，降浊除痞；黄芩、黄连苦寒降火，泄其结热；人参、甘草、大枣温补中气，以消痞塞之气。此方寒热并用，故能交通阴阳，则诸证可解。

【选注】

《金匮要略论注》：“呕本属热，然而肠鸣则下寒而虚。痞者阴邪搏饮，结于心下，即《伤寒论》所谓胃中不和，腹中雷鸣也。故主半夏泻心汤。用参、甘、枣以补中，干姜以温胃泄满，半夏以开痰饮，而以芩、连清热，且苦寒亦能泄满也。”

11.干呕而利者，黄芩加半夏生姜汤主之。

黄芩加半夏生姜汤方

黄芩三两 甘草二两，炙 芍药一两 半夏半升 生姜三两 大枣十二个
上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再、夜一服。

【诠解】

本条是论述干呕兼热利的证治。由于饮食不洁，肝胆不和，热郁胃肠，以致升降失调，胃气上逆，则干呕；邪热下迫，故下利。因是热利，当见大便稠黏或赤白；或伴有发热、腹痛等证。

治宜黄芩加半夏生姜汤和胃降逆，清热止利。方中黄芩、芍药清肝胆之热，使其不灼伤肠液，则下利自止；半夏、生姜和胃降逆，而治干

呕；甘草、大枣则调理中气而和诸药。

【选注】

《金匱要略直解》：“中焦不和，则气逆于上而作呕，迫于下而不利，故用半夏、生姜入上焦而止呕；甘草、大枣入中焦而和脾；黄芩、芍药入下焦而止利。如是则正气安而邪气去，三焦和而呕利止矣。”

12.诸呕吐，谷不得下者，小半夏汤主之。方见痰饮中。

【诠解】

本条是论停饮呕吐的证治。由于胃中有停饮，脾胃升降失调，寒饮上逆，故呕吐，谷不得下。饮邪聚结于中焦，故心下痞满。

治宜小半夏汤，蠲饮止呕。小半夏汤有健胃涤痰散饮与调气止呕之功。若本证兼膈间水饮而心下痞与心悸，或清阳不升而有眩冒证，则用小半夏加茯苓汤，以加强渗湿治饮之功。

【选注】

《金匱要略心典》：“呕吐，谷不得下者，胃中有饮，随气上逆，而阻其谷入之路也，故以半夏消饮，生姜降逆，逆止饮消，谷斯下矣。”

【病案举例】

徐某，女，5岁，1978年4月16日诊，呕吐两天，有便不泻，不能饮食，食饮即吐。患儿神萎疲乏，面色晦滞，肌肤干涩，目闭睛露，呼吸深快，似喘非喘，频频空呕，不时以口唇弄舌。两天来使用过阿托品、鲁米那、灭吐灵等无效。腹痞满，脉沉细涩，唇红舌干，苔薄白微腻，给小半夏汤，煎煮少量频服。

处方：姜半夏6克，鲜生姜5片。

服药后呕哕渐止，服二煎后，即安睡不再吐。二诊处方：太子参10克，儿茶3克。泡茶饮服。两日后恢复正常。

（摘自《江苏中医杂志》1980,6:59）

13.呕吐而病在膈上，后思水者解，急与之。思水者，猪苓散主之。

猪苓散方

猪苓 茯苓 白术各等分

上三味，杵为散，饮服方寸匕，日三服。

【诠解】

本条是论述停饮呕吐的调治方法。由于胃中停饮，溢于膈上，故呕吐清水痰涎。呕吐之后，饮去阳复，则口渴饮水，故先呕后渴，为饮邪欲解。由于旧饮方去，胃阳尚未全复，虽渴，只宜少饮，令阳和阴生则愈。若恣意多饮，必伤胃阳，胃虚不能游溢精气，则新饮又生。

治宜猪苓散，利水行津，健脾化湿。方中猪苓利水化饮；白术健脾化湿；茯苓则渗湿利小便。三药相使，则饮停可去，诸证即愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“病在膈上，病膈间有痰饮也；后思水者，知饮已去，故曰欲解，即先呕却渴者，此为欲解之义。夫饮邪已去，津液暴竭而思得水；设不得，则津亡而气亦耗，故当急与；而呕吐之余，中气未复，不能胜水，设过与之，则旧饮方去，新饮复生，故宜猪苓散以崇土而逐水也。”

【病案举例】

消化不良系两岁内小儿常见疾病，临床表现为腹泻、呕吐、腹痛或发热等症。笔者用猪苓散（《金匱要略》）加半枝莲治疗小儿单纯性消化不良，经近几年临床应用，效果满意，特介绍如下：

方药及用法：猪苓10克，茯苓10克，白术10克，半枝莲20克。水煎服，每日一剂。一岁内小儿用量酌减。一般1~3剂即愈。

病例：杨某，女，7个月。1979年9月20日诊。患儿发病已两天，经西医诊断为小儿单纯性消化不良，曾用西药效果不佳。大便稀呈蛋花状，每天十余次，小便少，伴有轻微呕吐，精神不振，舌质红苔白，脉细数，体温38℃。用此方两剂，诸证痊愈。

（摘自《陕西中医》1981,6:11）

14.呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者，难治。四逆汤主之。

四逆汤方

附子一枚，生用 干姜一两半 甘草二两，炙

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

【诠解】

本条论述虚寒呕吐的证治。由于脾肾阳衰脉来而弱；阳衰阴盛，胃中阴寒上逆，故见呕吐；脾肾阳衰，气不制水，故小便反多；阳衰不暖四末，故四肢厥冷；阴寒内盛，格阳于外，则身微热。此为阴盛阳衰的危重证，故曰：难治。

治宜四逆汤，回阳救逆，祛寒消阴。方中附子温暖肾阳；干姜温中散寒，以降寒逆；甘草健脾和胃，以缓阴气之逆，以将附子回阳温寒。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉弱，便利而厥，为内虚且寒之候，则呕非火邪，而是阴气之上逆；热非实邪，而是阳气之外越矣，故以四逆汤救阳驱阴为主。然阴方上冲，而阳且外走，其离决之势，有未可即为顺接者，故曰难治。或云：呕与身热为邪实，厥、利、脉弱为正虚；虚实互见，故曰难治，四逆汤舍其标而治其本也，亦通。”

15.呕而发热者，小柴胡汤主之。

小柴胡汤方

柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 甘草三两 半夏半升 生姜三两 大枣十二枚

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【诠解】

本条论述肝胆不和的呕吐证治。由于邪热郁于肝胆，正邪相争，故见发热，或往来寒热；肝胆之邪犯胃，则使胃气上逆而为呕吐。“呕而发热”在《伤寒论》中则有针对“干呕，吐涎沫，头痛者”而不发热的意思。

治宜小柴胡汤疏肝和胃，泄热止呕。方中柴胡透少阳之邪热；黄芩清泄少阳之热；生姜、半夏和胃降逆；甘草、人参、大枣补脾生津，护正驱邪。

【选注】

《金匱要略直解》：“经曰：呕而发热者，柴胡证具。夫呕家未有发热者，以发热属半表半里，故与小柴胡汤以和之。”

16.胃反呕吐者，大半夏汤主之。《千金》云：治胃反，不受食，食入即吐。《外台》云：治呕，心下痞硬者。

大半夏汤方

半夏二升，洗完用 人参三两 白蜜一升

上三味，以水一斗二升，和蜜扬之二百四十遍，煮药取二升半，温服一升，余分再服。

【词解】

胃反：即反胃的互义。

【诠解】

本条论述虚证的胃反，而与下文实证胃反相对比。由于胃虚不降，脾虚不升，宿食不得消化，则朝食暮吐，暮食朝吐，病名曰胃反。因其胃气上逆，故趺阳脉浮；脾虚而阴血虚少，故脉来亦涩。

治宜大半夏汤，补虚安胃，以治呕吐。方中半夏和胃降逆止呕；人参补脾胃之虚，复运化之职；白蜜补虚润燥，使胃气不降而大便畅通。三药相使，有益虚润燥、安胃止呕的功用。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“此反胃即脾阴不濡，胃气独逆，今之膈食病是矣。或粪如羊屎，或吐后微带血水。用半夏降冲逆，即是降胃；用参、蜜滋脾液以濡化水谷，则肠润谷下。”

17.食已即吐者，大黄甘草汤主之。《外台》方又治吐水。

大黄甘草汤方

大黄四两 甘草一两

上二味，以水三升，煮取一升，分温再服。

【诠解】

本条是论述实热呕吐的证治。由于胃肠实热，大便秘结不通，胃气不能下降，火热之邪上逆，故食已即吐。由于火邪急迫，故其吐势甚急而不能久待也。

治宜大黄甘草汤，泄热降逆止吐。方中大黄泄肠胃实热积滞，通畅六腑，荡涤肠胃，可降胃气之逆；甘草和胃安中以缓大黄直走下焦，二药相配，则甘草载大黄以泄胃热，使胃气得降，则呕吐自止。

【选注】

《金匮要略论注》：“食已即吐，非复呕病矣，亦非胃弱不能消，乃胃不容谷，食已即出者也。明是有物伤胃，荣气闭而不纳，故以大黄通荣分已闭之谷气，而兼以甘草调其胃耳。《外台》治吐水，大黄亦能开脾气之闭，而使散精于肺，通调水道，下输膀胱也。”

《金匮要略浅注》：“又有阳明有热，大便不通，得食则两热相冲，食已即吐者，以大黄甘草汤主之。此为食入即吐者出其方治也。东垣谓幽门不通，上冲吸门者，本诸此也。”

【病案举例】

李某，男，20岁，打铁工人。

1974年11月10日就诊：患者近半月呕吐，胃脘热痛，大便干燥，舌质红，苔薄黄少津，脉实有力，右关脉滑，精神尚佳。平时喜食烙饼。初认为是胃热上逆之呕吐，拟以清热和胃之法主治，用连苏饮加竹茹、甘草。嘱服2剂。

11月12日复诊，服上方无效。仍每餐刚完即吐（平时不吐），并伴口臭，胃脘灼热，胀痛，大便3日未解，小便短黄，舌质红，苔薄黄少津，脉滑有力。《金匮要略》云：“食已即吐者，大黄甘草汤主之。”从证候分析，亦恰合病机，系积热在胃，腑气不通，胃热上冲之呕吐。改用泄热和胃之大黄甘草汤：大黄12克，甘草3克。嘱服2剂。

11月16日到家随访，上方服1剂后，食已不吐，大便畅通，服完2剂，诸证消失。

（摘自《成都中医学院学报》1979,2:57）

18.胃反，吐而渴，欲饮水者，茯苓泽泻汤主之。

茯苓泽泻汤方

《外台》治消渴脉绝，胃反吐食之者，有小麦一升

茯苓半斤 泽泻四两 甘草二两 桂枝二两 白术三两 生姜四两

上六味，以水一斗，煮取三升，内泽泻再煮取二升半，温服八合，日三服。

【诠解】

本条是论述胃中停水呕吐的证治。由于胃虚停水，水气上逆故呕吐。脾虚不能运化，津液不能蒸腾上达，故渴欲饮水。因渴复饮，更助饮邪，以致停水愈多，呕吐愈甚。

治宜茯苓泽泻汤，利水行津，以治渴呕。方中茯苓淡渗利水行津；桂枝通阳以布津液；泽泻利水湿之滞，能行水上；白术、甘草健脾扶中，以制水湿之邪；生姜辛散水饮，健胃和中。诸药合用，使气化行而水饮去，胃气平而呕吐愈。

【选注】

《金匱要略浅注》：“今有挟水饮而病胃反，若吐已而渴，则水饮从吐而俱出矣；若吐未已而渴，欲饮水者，是旧水不因其得吐而尽，而新水反因其渴饮而增，愈吐愈渴，愈饮愈吐，非从脾而求输转之法，其吐与渴，将何以宁？以茯苓泽泻汤主之。”

19.吐后渴欲得水而贪饮者，文蛤汤主之。兼主微风、脉紧、头痛。

文蛤汤方

文蛤五两 麻黄 甘草 生姜各三两 石膏五两 杏仁五十个 大枣十二枚

上七味，以水六升，煮取二升，温服一升，汗出即愈。

【诠解】

本条论述呕吐的变证与治法。呕吐之后，伤阴损阳，胃阴伤而阳热

内盛，故口渴贪饮。脾阳虚弱，不能运化，水饮复停，若饮停于内，复感风寒，风寒在表，故见头疼、脉紧、身肿等证。

治宜文蛤汤，宣肺利水，散结清热。方中文蛤咸寒，利水消饮；杏仁开肺利水；麻黄、石膏发越水气，透邪于外；甘草、生姜、大枣健脾温胃，化饮生津。诸药相合，使水饮从皮表散去，内热从汗而透出，故方后注云“汗出即愈”。

【选注】

《医宗金鉴》：“吐后而渴，当少少与饮之，胃和吐自止也。若恣意贪饮，则新饮复停，而吐必不已也，当从饮吐治之。若兼感微风，脉必紧，头必痛，主之文蛤汤者，是治渴兼治风水也。故以越婢汤方中加文蛤。越婢散风水也，文蛤治渴不已也。”

20.干呕吐逆，吐涎沫，半夏干姜散主之。

半夏干姜散方

半夏 干姜各等分

上二味，杵为散，取方寸匕，浆水一升半，煎取七合，顿服之。

【诠解】

本条是论胃寒呕吐的证治。由于胃中寒盛，津液不化，凝为痰涎，胃气上逆，则干呕，吐逆，吐涎沫。

治宜半夏干姜散温胃化饮，降逆止呕。方中半夏化饮止呕；干姜温胃理中，以浆水煮散，则有调中开胃之效。“顿服之”可使药力集中，取效为速。

【选注】

《金匱要略心典》：“干呕吐逆，胃中气逆也；吐涎沫者，上焦有寒，其口多涎也。与前干呕、吐涎沫、头痛不同，彼为厥阴阴气上逆，此是阳明寒涎逆气不下而已。故以半夏止逆消涎，干姜温中和胃，浆水甘酸，调中引气止呕哕也。”

21.病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻心中愤愤然无奈者，生姜半夏汤主之。

生姜半夏汤方

半夏^{半升} 生姜汁一升

上二味，以水三升，煮半夏取二升，内生姜汁，煮取一升半，小冷分四服，日三、夜一服，止，停后服。

【词解】

彻心中：当通连到心里讲。

愤愤然而无奈：愤愤然，指烦乱满闷；无奈，即无可奈何的意思。

【诠解】

本条是论正气与寒饮相争的证治。由于寒饮停于中焦，正气起而相争，寒饮上逆于胸，故似呕不呕，似哕不哕；寒饮闭阻胸阳，阳气不得伸展，以致肺气被郁，故似喘非喘；心阳被阻，正气与饮邪相争，故通连到心里愤愤然而无可奈何。

本证乃中焦寒饮上逆于胸中所致，故治宜生姜半夏汤，温寒散饮。本方以生姜汁配半夏，散胃中寒饮，温胸中阳气。使阳气振奋，寒饮消散，诸证则自愈。此方即小半夏汤，而生姜取汁，且重用之，姜汁保持了药的功效，对降逆散结其力为大，为治饮之良药。

生姜半夏汤的服法是“小冷，分四服”。因寒饮结于中焦，拒热药不进，呕吐加剧，故分四服，使量少而易于受纳。又因饮邪内结，难以速去，四服可使药力持久，逐渐消散内结之寒饮。

【选注】

《金匱要略心典》：“寒邪搏饮，结于胸中而不得出，则气之呼吸往来，出入升降者阻矣。似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，皆寒饮与气，相搏互击之证也。且饮，水邪也；心，阳脏也，以水邪而逼处心脏，欲却不能，欲受不可，则彻心中愤愤然无奈也。生姜半夏汤，即小半夏汤，而生姜用汁，则降逆之力少而散结之力多，乃正治饮气相搏，欲出不出者之良法也。”

22.干呕，哕，若手足厥者，橘皮汤主之。

橘皮汤方

橘皮四两 生姜半斤

上二味，以水七升，煮取三升，温服一升，下咽即愈。

【诠解】

本条是论胃寒呕哕的证治。由于胃寒之气闭阻胸膈，气逆不降，则干呕或哕。中阳被阻，不达四末，则四肢厥冷。

治宜橘皮汤，温胃理气。方中生姜温胃散寒；橘皮理气降逆。两药相合，使寒邪消散，阳气畅通，则呕哕厥冷之证均解。

【选注】

《金匮要略论注》：“呕兼哕言，则以哕为重矣。彼有因元气败而哕者，此肾虚欲绝也。若从干呕来，虽手足厥，明是胃家寒气结，不行于四肢，故以橘皮温胃为主，而合生姜以宣散其逆气也。”

23.哕逆者，橘皮竹茹汤主之。

橘皮竹茹汤方

橘皮二斤 竹茹二升 大枣三十枚 生姜半斤 甘草五两 人参一两

上六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服。

【诠解】

本条是论述虚热哕逆的治法。由于中焦气虚，谷气不宣，郁而化热，虚热上逆，故见哕逆。

治宜橘皮竹茹汤补虚和中，清热降逆。方中橘皮、竹茹，宣畅胃气，清虚热，降逆气；人参、甘草、大枣、生姜补中益气，调胃止呕。诸药相使，以奏补虚安中、和胃降逆之功。

本方补中益气之品较多，用量亦大，故本方适用于中气虚而挟有热饮之哕逆。

【选注】

《金匮要略编注》：“此胃虚受邪致哕也。胃虚受邪，挟痰冲肺则哕。然胃气虽虚，是非虚败哕逆，但是胃中邪气不散。故以人参、甘草养胃和中；姜、枣补胃，而宣通中上二焦营卫，俾中气和而肺气自能散布；竹茹善清风邪胃热，能消热痰；橘皮以散胃逆之气。”

【病案举例】

周某，男，22岁，因发热头痛15天，于1980年5月21日住我院治疗。

患者1980年5月7日开始发热，体温在38.5~39.5℃之间，伴有头痛较剧烈且进行性加重，卫生队给予解热止痛药无效。自诉1979年至此次入院前，先后患左上肺浸润型肺结核、疟疾、痢疾、左侧髂窝冷性脓疡等多种疾病。检查：体温39℃，脉搏106次/分，血压120/70毫米汞柱。发育营养佳，消瘦，神志清楚，痛苦表情，呻吟不止，颈项强直，心肺无异常，肝脾未触及，腹部无压痛，肠鸣音正常，两侧克氏征阳性，巴氏征阴性。血象及粪、尿常规均正常。腰穿脑脊髓液压力升高，白细胞50立方毫米，淋巴细胞85%，蛋白(+++)。生化检查蛋白320毫克%，氯化物680毫克%，糖30毫克%，抗酸染色无发现结核杆菌，革兰染色无细菌，培养无细菌生长，气氨酸试验阳性。诊断为结核性脑膜炎。给予雷米封每天900毫克，对氨基水杨酸钠每天12克静脉滴注，脑膜刺激征减轻，入院第八天出现呃逆，逐日加重，白天连续发作7~8小时，夜间亦发作，严重时影响睡眠及进食，且出现呕吐，上腹部疼痛不适。给予镇静剂、解痉剂、针灸及耳针等多种治疗，症状继续加重，故转中医诊治。经中医辨证认为：

本例一年来患多种疾病，久病必虚，舌质红，脉细弱无力，为胃虚挟热之症，治应益胃气，清胃热，降逆止呕。橘皮竹茹汤加味：

党参15克，竹茹9克，白术12克，茯苓12克，橘皮9克，生姜3片，大枣4枚，麦芽9克，炙甘草2克。

上方每日一剂，服一剂后呃逆减轻，共服三剂，呃逆完全停止，停药后至今无复发。

（摘自《新中医》1980,12:4）

24.夫六腑气绝于外者，手足寒，上气脚缩，五藏气绝于内者，利不禁，下甚者，手足不仁。

【诠解】

本条承上启下，从脏腑功能的虚衰，阐述呕吐、哕、下利的病机。六腑为阳而主外，以胃为本。故胃阳一衰，则诸腑之气皆衰。胃虚不化水谷，胃气上逆，故呕吐或哕。上焦之气不能来于中焦，宗气为之不足，故上气喘促；下寒不得温煦，寒凝筋脉不能舒张，则两脚缩急。

五脏为阴并主内，肾为诸脏之本，故肾阳微，诸脏之气即弱。肾阳衰微，不能温焙脾胃，则水谷不得腐熟，寒滑下行而不能自主，故利下

不禁。下利过甚，由阳及阴，则血痹不行，肢体不得濡养，故手足不仁。

呕吐下利诸病的发展，开始在胃肠，先传至脾，后传至肾，这是疾病发展的一般规律。临证时，要掌握疾病传变规律，才能在治疗时，预先防止疾病的传变，而有临床积极意义。

【选注】

《医宗金鉴》：“气绝非谓脱绝，乃谓虚绝也。六腑之气，阳也，阳气虚不能温于外，则手足寒缩。阳虚则阴盛上逆，故呕吐也。五脏之气，阴也，阴气虚不固于中，则下利不禁，利甚则中脱形衰，故手足不仁也。此发明呕吐、下利之原委也。”

25.下利脉沉弦者，下重；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热不死。

【诠解】

本条是从脉象辨别下利病机的进退状况。本证由于寒湿内侵胃肠，寒湿在里，故脉沉弦。寒湿阻滞气机不畅，则下利腹痛，里急后重，故曰“下重”；若下利而脉反大的，为邪气不衰，故知下利未止；若下利正邪皆衰，阳气开始恢复，则脉微弱之中而带数，故知下利将自止，虽有发热之证，亦为正复之征，预后亦是令人高兴的，故曰“虽发热不死”。

【选注】

《金匱要略心典》：“沉为里、为下，沉中见弦，为少阳之气滞于下而不得越，故下重；大为邪盛，又大则病进，故为未止，徐氏曰；微弱者，正衰邪亦衰也。数为阳脉，于微弱中见之，则为阳气将复，故知利欲自止，虽有身热，势必自己，不得比于下利，热不止者死之例也。”

26.下利，手足厥冷，无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者死。少阴负趺阳者，为顺也。

【词解】

负：败也。

趺阳者：胃脉也。在足趺上五寸骨间，即足阳明经冲阳穴，按之其脉应手而起。

【诠解】

本条是论述下利损伤脾肾的证治和预后。阴寒下利甚重，损伤脾

肾，脾肾虚寒，阳随阴脱，故手足厥冷，无脉。当以回阳急救，用艾灸之法，灸其关元、气海而温暖脾肾阳气，以复其脉。如灸后脉气不复者，为阳气不回。若又见微喘，乃阴气下竭，阳气上脱，阴阳离决之危象。故曰“死”，如少阴脉负，趺阳脉胜，为土强水弱，脾胃阳气来复，有胃气者能生，则可转危为安，故曰“为顺”。

【选注】

《金匱要略心典》：“下利，厥冷，无脉，阴亡而阳亦绝矣。灸之所以引既绝之阳，乃厥不回、脉不还，而反微喘，残阳上奔，大气下脱，故死。下利为土负水胜之病，少阴负趺阳者，水负而土胜也。故曰顺。”

27.下利，有微热而渴，脉弱者，今自愈。

【诠解】

本条是论述下利病愈的脉证。由于阴寒下利，邪去正衰，故微热而渴，为胃阳来复；又脉来柔弱不实，方为下利自愈之象。

【选注】

《金匱要略论注》：“假令微热是邪出表也，而渴是胸中阳胜也，且脉弱则在内之邪气少矣，虽不治之，邪祛，正自复，故令自愈。”

28.下利脉数，有微热汗出，今自愈；设脉紧，为未解。

【诠解】

本条是论下利自愈与未解的脉证。由于阴寒下利，邪退正弱，阳气恢复，外达于表，表里俱和，故见脉数，微热汗出，此为自愈之征。假如脉不弱而紧者，为邪势强盛，正气未复，故为未解。

【选注】

《金匱要略论注》：“若既有微热，脉不弱而数，数亦阳胜也，更汗出，则热从外泄矣，故亦令自愈。设脉数中兼紧，则寒邪尚坚，为未解矣。”

29.下利，脉数而渴者，今自愈；设不差，必清脓血，以有热故也。

【词解】

清：同圉，指大便而言。

【诠解】

本条是论下利发热的两种病情变化。阴寒下利，邪去正衰，阳气未复，故脉数而渴，今自愈。如果阴气未复，阳复太过，内热壅盛，热伤胃肠脉络，则下利脓血。

【选注】

《金匮要略论注》：“若数脉与渴并见，亦是阳胜故令自愈；设不瘥，则寒既退而病不退，不宜责寒矣。乃热多，必反动其血，故曰必圉脓血，以有热故矣。”

30.下利，脉反弦，发热身汗者，自愈。

【论解】

本条亦论下利自愈的脉证。虚寒下利是由于阴寒内盛，阳气被郁，而不得伸发，故脉弦。若阳气初升向外伸展，故身热汗出。邪衰阳复，阴阳自和，下利自愈。

【选注】

《金匮要略论注》：“若发热而汗与上同，更脉弦，则里证见弦为阳脉，是阳胜也，阳胜则愈。”

31.下利气者，当利其小便。

【词解】

下利气：是指泄泻与矢气并见，亦称“气利”。

【论解】

本条是论利气的证治。由于湿热郁滞于胃肠，气机不畅，水谷不化，郁热腐败，故下利而兼矢气。由于湿热阻滞气机，故有小便不利，肠鸣胀满等证。治当利其小便，分利肠中湿热，气化恢复正常，则下利矢气可除。如果中气不足，宜补中利湿以升清阳。

【选注】

《金匮要略心典》：“下利气者，气随利失，即所谓气利是也。小便得利，则气行于阳，不行于阴而愈，故曰当利其小便。喻氏所谓急开支河者是也。”

32.下利，寸脉反浮数，尺中自涩者，必清脓血。

【论解】

本条是论热利下脓血的病机。由于湿热熏蒸胃肠，热盛上升，故寸脉浮数。热伤下焦阴血，阴血凝涩不畅，故尺脉涩。下焦浊热而伤阴，

故便脓血。本证亦常见下利腹痛，里急后重等证。

【选注】

《金匱要略论注》：“若下利果属寒，脉应沉迟。反浮数，其阳盛可知；而尺中自涩，涩为阳邪入阴，此亦热多，故曰必圉脓血。”

33.下利清谷，不可攻其表，汗出必胀满。

【论解】

本条是论虚寒下利的禁忌。由于脾肾虚寒，不能温化水谷，故下利清谷。若误用发汗之法，则阳气益虚，阴寒更重，则腹部胀满，亦常伴有腹痛。所以，脾肾虚寒下利，应忌发汗，恐其损阴伤阳，使病情恶化。

【选注】

《金匱要略心典》：“清与圉同，即完谷也。是为里虚气寒，乃不温养中土，而反攻令汗出，则阳气重虚。阳虚者气不化，故胀满。”

34.下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴阳，下虚故也。

【词解】

郁冒：头目眩晕。

微厥：四肢微冷。

戴阳：阳气离根而格拒于上的名称。

【论解】

本条是论述脾肾虚寒下利的病机。由于脾肾阳虚，阴寒内盛，故脉沉迟。虚寒不能消谷，故下利清谷；阴寒内盛，格阳于外，虚阳上浮，故其人面少赤，身有微热。若阳气抗邪，与阴寒相争，阳伸而邪却时，则必见郁冒之证，随之汗出而解。由于阳气本虚，抗邪于外，不能达于四末，故手足厥逆。为什么会出现这种情况呢？人面见戴阳，为肾虚于下，故在作解时，有冒汗的特点。

【选注】

《金匱要略浅注》：“下利脉沉而迟，其为阴盛阳虚无疑矣。阳虚则气浮于上，故其人面少赤，虽身有微热，尚见阳气有根；其奈阳不敌阴，为下利清谷，而不能遽止者，是阳热在上，阴寒在下，两不相接，惟以大药救之，令阴阳和，上下通，必郁冒汗出而解；然虽解而病人必微厥。所以然者，其面戴阳，阳在上而不行于下，下焦阳虚故也。”

35.下利后脉绝，手足厥冷，晬时脉还，手足温者生，脉不还者死。

【词解】

晬时：即一昼夜二十四小时。

【诠解】

本条是论述下利重症的病机、转归。脾肾阳虚，下利之后，耗阴损阳，阳随阴脱，津液内竭，故无脉，手足厥冷。经过一昼夜（包括服药在内），若阳气复回，则脉续出，手足温暖，故为生。如脉不返者，则阴阳不续，故主死。

【选注】

《金匱要略心典》：“下利后脉绝，手足厥冷者，阴先竭而阳后脱也。是必俟其晬时，经气一周，其脉当还，其手足当温；设脉不还，其手足亦必不温，则死之事也。”

36.下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。

四逆汤方方见上

桂枝汤方

桂枝三两，去皮 芍药三两 甘草三两，炙 生姜三两 大枣十二枚

上五味，**㕮咀**，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温服一升，服已，须臾啜稀粥一升，以助药力，温复令一时许，遍身**𦛖𦛖**微似有汗者益佳，不可令如水淋漓，若一服汗出病差，停后服。

【词解】

㕮咀：捣碎药物。

啜：大口喝粥。

𦛖𦛖：和润而欲汗之貌。

【诠解】

本条是论述虚寒下利兼表证的证治。由于脾肾阳虚，阴寒内盛，运化失司，故下利腹胀满；又有风寒侵袭肌表，故身体疼痛。本证为表里皆病。如正气实者，则先解表，而后治里，今正气先虚，里寒为急，故先用四逆汤温其里，待里阳充实以后，则下利自止。然后，用桂枝汤解散表邪，调和营卫。本条说明表里同病，应该分清先后缓急，遵循急者先治、缓者后治的原则。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“盖内有虚寒，故下利腹胀满。表邪未解，故身体疼痛。以下利为重先治其里，后治其表者。若《伤寒论》太阳证，以医下之，续得下利清谷，身疼痛者，当先以四逆治其里，清便自调，然后以桂枝救其表，即此意。”

37.下利三部脉皆平，按之心下坚者，急下之，宜大承气汤。

【词解】

三部脉皆平：指寸、关、尺三部脉象不大也不小，不虚亦不实。

【论解】

本条是论述下利属于实邪的脉证。由于肠胃食滞郁结，腑气不畅，积滞郁而不化，亦可出现下利，所谓伤食作泻者是也。如以手按之，其人心坚满不软的，则知宿食内结已成不拔之势，故当急下，以荡涤肠胃之实，宜大承气汤。泻其有形之邪，使腑气通顺，则下利之证可除。“三部脉皆平”，似有舍脉从证之意。

【选注】

《金匱要略心典》：“下利有里虚脏脱者，亦有里实腑闭者，昔人所谓利者不利是也；按之心下坚，其证的矣，脉虽不实大，而亦未见微弱，自宜急下，使实去则利止，通因通用之法也。”

38.下利脉迟而滑者，实也，利未欲止，急下之，宜大承气汤。

【论解】

本条是论述食积中阻影响肠胃而下利的脉证。由于食积伤胃，积滞中阻，气机不畅，故脉迟而滑，而证为实非虚，故积滞不消，则下利不止，治以急下之法。以大承气汤荡积腐垢，则下利自止，而又预防了利下亡阴之弊。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉迟为寒，然与滑俱见，则不为寒而反为

实，以中实有物，能阻其脉行之机也。夫利因实而致者，实不去则利不已，故宜急下。”

39.下利，脉反滑者，当有所去，下乃愈，宜大承气汤。

【诠解】

本条是论实积下利的脉证。下利最易伤阴损阳，故常见微弱之脉。今反见滑而有力之脉，是有宿食积滞，郁而不消。宜用大承气汤下其实邪，则利可止。

【选注】

《医宗金鉴》：“下利脉反滑者，是病虚脉实，不相宜也。若其人形气如常，饮食如故，乃有当去之积未去也。下之乃愈，宜大承气汤。”

40.下利已差，至其年月日时复发者，以病不尽故也，当下之，宜大承气汤。

大承气汤方见痙病中

【诠解】

本条是论下利复发的“休息痢”的证治。本证是痢疾已愈，由于旧积残邪，隐僻肠间，未能根除，又因气候、饮食劳倦等诱因而复发，故曰“至其年月日时复发者，以病不尽故也”。这种痢疾，亦称“休息痢”。治宜大承气汤攻下不尽之邪，方能痊愈。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“飧清洞泻无至期复发之证，惟痢证有去年泻痢，今年复发者，乃湿热未尽，至来年长夏感湿热之气，内外合邪，故期而复发。”

41.下利谵语者，有燥屎也，小承气汤主之。

小承气汤方

大黄四两 厚朴三两，炙 枳实大者三枚，炙

上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服，得利则止。

【诠解】

本条是论下利有燥屎的证治。由于胃肠实热积滞，燥屎内结不去，致使下利臭秽黏滞；燥热上蒸，故见谵语。由于阳明实热，故常见心腹坚满，舌苔黄厚干燥，脉滑数等证。治以小承气汤，导滞泄热，去其病根，则谵语与下利等证可除。

【选注】

《金匱要略心典》：“谵语者，胃实之征，为有燥屎也；与心下坚，脉滑者大同。然前用大承气者，以因实而致利，去之惟恐不速也；此用小承气者，以病成而适实，攻之恐伤及其正也。”

42.下利便脓血者，桃花汤主之。

桃花汤方

赤石脂一斤，一半剉，一半筛末 干姜一两 粳米一升

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温七合，内赤石脂末方寸匕，日三服，若一服愈，余勿服。

【诠解】

本条是论虚寒下利，下焦不固的证治。由于脾胃虚寒，中阳被伤，气血下陷，下利无度，滑脱不禁，阳伤及阴，血溢于下，故下利脓血。因其证属虚寒，故往往有腹疼喜按，精神萎靡，四肢酸软，舌淡苔白等证。

治宜桃花汤，温寒固脱，以止下利。方中赤石脂固涩下焦，暖血止利；干姜温中守阳；粳米养胃补虚。诸药相配，以奏温寒固脱，补虚安中之功。

【选注】

《金匱要略心典》：“此治湿寒内淫，脏气不固，脓血不止者之法。赤石脂理血固脱，干姜温胃驱寒，粳米安中益气。”

【病案举例】

马某，女，63岁，1981年4月12日诊。有糖尿病史已十余年，近十日前，因服生冷而诱发呕吐泄泻，腹痛肢冷。在输液治疗时突发休克，急送医院抢救，休克被纠正，但下利仍不止，输氯霉素不效，改用青霉素静滴。在输液时又突发心烦，全身起紫疱。停药后仍烦躁欲死，下利失禁，色呈暗紫，四肢厥冷，舌淡苔白，脉虚数。此正虚阳败之危候，以回阳救逆为急务。停用西药，投四逆加人参汤1剂。服后烦躁止，四肢稍温，但利下仍不止，面色青黄，周身微凉，腹部发凉，神志恍惚，身有紫斑，脉舌如前。证属中阳虚衰，下元失固，治宜温中益气，涩肠健脾。

方用：赤石脂、茯苓各30克，干姜15克，粳米60克，红参10克。

服2剂后，神志清醒，四肢温和，4剂后，血利止，继以他药调治而愈……掌握药物的煎服法，是提高疗效的关键之一。仲景在方后云：“以水七升，煮米熟去滓，温服七合，纳赤石脂末方寸匕，日三服。”我们在临床中对大便滑泄不止者，以上法煎服，对吐血及腹痛者，三药同煎，三煎兑合一起，混匀频服。

（摘自《浙江中医杂志》1982,8:378）

43.热利下重者，白头翁汤主之。

白头翁汤方

白头翁二两 黄连 黄柏 秦皮各三两

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升，不愈更服。

【诠解】

本条是论湿热下利的证治。由于肝不疏泄，湿热壅盛，下迫于肠，热伤血络，腐血化热，故下利脓血，血色鲜明，肛门灼热，下重难通，黏滞而臭。因证是湿热为患，故常有身热烦渴，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉数而滑等证。

治宜白头翁汤，疏肝清热，燥湿止利。方中白头翁疏肝清热凉血，解毒治利；秦皮凉肝清热；黄连、黄柏燥湿坚阴。诸药合用，共奏清热

燥湿，凉血治利之功。

【选注】

《金匱要略浅注》：“热利下重者，热邪下入于大肠，火性急速，邪热甚则气滞壅闭，其恶浊之物，急欲出而未得遽出故也，以白头翁汤主之。此为热利之后重出其方治也，辨证全在后重，而里急亦在其中。”

【病案举例】

董某，女，51岁，1964年6月26日诊。

下痢赤白，腹痛如绞，一夜行十余次，里急后重，食欲毫无，但尚能勉进饮食，口干作苦，不渴，舌质淡红，苔白微干，小便黄而少，脉细，无表寒恶热情况。初诊投服马齿苋90克，广木香9克，焦楂6克，煎服。连进二剂，一夜仅行4~5次，脓血均减，腹痛也显著减轻。原方再服，至27日晚，病情忽有反复，下利便脓血及里急后重又都如故。换服加味香连丸每日3次，每次9克，至29日仍无效。口干不渴，舌质瘦，舌红，尖有细微芒刺，苔薄白略干，脉象沉细而缓，食欲仍无，腹痛里急，脓血杂下，日行30余次。认证为热痢，过在厥阴湿热郁滞，予白头翁汤加味：

白头翁12克，炒黄柏6克，秦皮9克（当时缺黄连故未用），炒白芍9克，甘草9克。煎200毫升，分2次服，二剂连进。药后一夜只解2次，里急后重显著减轻，腹痛偶有存在，继服二剂痊愈。

本例前治三日效果不稳，后投白头翁汤清热厚肠，加白芍、甘草养阴，迅速痊愈。

（摘自《中医杂志》1980,2:59）

44.下利后，更烦，按之心下濡者，为虚烦也，栀子豉汤主之。

栀子豉汤方

栀子十四枚 香豉四合，绵裹

上二味，以水四升，先煮栀子，得二升半，内豉煮取一升半，去滓，分二服，温进一服，得吐则止。

【诠解】

本条是论述下利之后的热郁虚烦证治。一般说下利之后，热去正安

而不烦。今不然，下利之后而更烦，这反映了胃肠已无滞热，按之而心下濡；热邪蕴郁于膈，然无物可攀缘，故其烦为“虚烦”，而非阳明实烦之可比。

治宜栀子豉汤清热除烦。方中栀子清泄心胸之郁热，解毒除烦；豆豉宣泄在上之热。两药相须，能宣泄郁热，以除虚烦。

【选注】

《金匱要略心典》：“下利后更烦者，热邪不从下减，而复上动也；按之心下濡，则中无阻滞可知，故曰虚烦。香豉、栀子能撤热而除烦，得吐则热从上出而愈，因其高而越之之意也。”

45.下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。

通脉四逆汤方

附子大者一枚，生用 干姜三两，强人可四两 甘草二两，炙
上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。

【诠解】

本条是论下利阴盛格阳的证治。由于脾肾阳虚，阴寒内盛，水谷不消，则下利清谷；阴盛而格阳于外，故有身微热、汗出，或面色微赤等证，此为真寒假热之象。由于下利为甚，阴从下竭；外热汗出，则阳从外脱，阴阳之气不能相接，故汗后而厥，或有脉微欲绝等证象。

本证病势比四逆汤证更为严重而且成危笃之势。治宜通脉四逆汤回阳散寒，复脉救逆。本方即四逆汤加倍干姜和附子的剂量。方中皆辛温大热之品，能通阳消阴，以收复亡失之阳气。

【选注】

《金匱要略心典》：“挟热下利者，久则必伤脾阴；中寒清谷者，甚则并伤肾阳；里寒外热，汗出而厥，有阴内盛而阳外亡之象。通脉四逆，即四逆加干姜一倍，所谓进而求阳，以收散亡之气也。”

46.下利肺痛，紫参汤主之。

紫参汤方

紫参半斤 甘草三两

上二味，以水五升，先煮紫参取二升，内甘草煮取一升半，分温三服。疑非仲景方

【诠解】

本条是论下利肺痛的证治。由于湿热浊气郁滞于胃肠，气机不畅，升降失常，湿浊迫于下，则下利；湿热之气上逆，壅塞胸膈，以致呼吸则肺中作痛，肺与大肠相表里，故邪气上下为病有如斯者。

治宜紫参汤清热除湿，行气止痛。方中紫参味苦辛寒，除心腹积聚、胃中热积而通利肠道；甘草和中调气。两药相须，使郁滞消除，气机宣畅，下利肺痛可愈。

【选注】

《金匱悬解》：“肺与大肠为表里，肠陷而利作，则肺逆而痛生，而肺肠之失位，缘中气之不治。脾土不升，而后肠陷；胃土不降，而后肺逆，紫参汤中甘草补中而缓急，紫参清金而破瘀，瘀去气调，各复肺肠升降之属，则痛定而利止矣。”

47.气利，诃梨勒散主之。

诃梨勒散方

诃梨勒十枚，煨

上一味，为散，粥饮和，顿服。疑非仲景方。

【诠解】

本条论虚寒气利的证治。由于中气下陷，肠虚不固，每见矢气时大便可随之而出，故病名为“气利”。

治宜诃梨勒散，温涩固肠，以止气利。方中诃梨勒消化饮食，健脾宽中，涩肠固脱；粥饮和服，则有补益胃肠之功。

本篇三十一条“下利气者”属于湿热郁滞，肠道气机失于宣畅所致。本证是因气虚不固所引起，一虚一实，病情大异。

【选注】

《金匱要略心典》：“气利，气与屎俱失也。诃梨勒涩肠而利气，粥饮安中益肠胃。顿服者，补下，治下，制以急也。”

【病案举例】

杨某，男，38岁。1957年秋，患痢疾已三天。小腹疼痛，里急后重，频欲登厕，每次多排出少量粉冻样肠垢，纯白无血，有时则虚坐努责，便之不出，自觉肛门有物嵌顿重坠，昼夜不已。前医曾予芍药汤加减，一剂后，病情加剧。舌苔白滑，脉沉带紧。询之知发病前后未见寒热现象，似属气痢。乃试用《金匱》诃梨勒散：柯子10枚（煨），剥去核研末，用米粥汤一次送服。约隔一小时许，当肛门窘迫难忍之时，经用力努挣，大便迅即直射外出，从此肛门部如去重负，顿觉舒适，后服调理脾胃之方而康复。

（摘自《浙江中医杂志》1980,8:356）

附方

《千金翼》小承气汤

治大便不通，哕，数谵语。方见上。

【诠解】

本条是论胃肠实热的证治。由于胃肠实热熏蒸，燥屎内结，腑气不畅，其气上逆，故见大便不通，哕而频频谵语。治以小承气汤通腑泄热，腑气通顺，诸证可解。

【选注】

《金匱玉函要略辑义》：“此条示哕用小承气之法，即上文哕而腹满，后部不利者。”

《外台》黄芩汤

治干呕下利。

黄芩 人参 干姜各二两 桂枝一两 大枣十二枚 半夏半升

上六味，以水七升，煮取三升，温分三服。

【诠解】

本条是论干呕下利并见的证治。由于中焦虚寒，不能运化水谷，郁结化热，胃气上逆，故干呕；虚寒不固，而见下利。

本证寒热错杂，但虚寒较重，热郁上逆较轻，故治宜黄芩汤温阳益气，清热降逆。方中人参、干姜、大枣、桂枝温中益气，调和脾胃，恢复脾胃升降之机；黄芩清解郁热；半夏降逆止呕。

【选注】

《金匱要略心典》：“此与前黄芩加半夏生姜汤治同，而无芍药、甘草、生姜，有人参、桂枝、干姜，则温里益气之意居多，凡中寒气少者，可于此取法焉。”

结语

呕吐哕的病机是胃失和降，胃气上逆所致。在治疗上，当以和胃降逆为主。属于虚寒性呕吐的，应宜温阳散寒，和胃降逆为主。如吴茱萸汤，治寒凝胸膈，寒饮上逆所致的呕吐；半夏干姜散，治中焦阳虚，干呕、吐逆、吐涎沫者；大半夏汤，治脾胃虚寒，不能消化水谷，以致朝食暮吐，暮食朝吐的“胃反”之证；四逆汤，治阴寒内盛，格阳于外而导致的呕吐，脉弱，身有微热，小便利，手足发冷的厥逆证。属于热性的呕吐，治宜清泄热邪，和胃降逆为主。如大黄甘草汤，治胃肠积热上冲的食已即吐证；小柴胡汤，治少阳邪热犯胃，引起的呕而发热等证；属于水饮停蓄所致的呕吐，应宜温散水饮，和胃降逆为主，如小半夏汤治饮停于胃，引起的呕吐证；生姜半夏汤，治寒饮上壅于胸，胸阳被郁，心肺不畅的呕逆证；猪苓散，治水饮上逆胸膈，呕吐口渴思水者；茯苓泽泻汤，治胃虚停水，呕吐而渴欲饮水者；文蛤汤，治停饮上溢于肺。如属脾寒郁热，导致呕吐肠鸣，心下痞者，用半夏泻心汤，辛开苦降，扶正祛邪。胃虚肠热，引起干呕、下利者，可用黄芩加半夏生姜汤，和胃降逆，清热止利。

呕逆之证，如有中焦虚寒，胃气上逆，引起干呕，哕，手足厥冷的，可用橘皮汤，温胃降逆；因胃虚郁热，胃气上逆，引起哕逆者，可用橘皮竹茹汤补虚和中，清热降逆；若见哕而腹满，因湿阻气机，小便不利，则宜利小便；因脾胃实热，气机不畅，大便干燥者，治宜通腑泄热，小承气汤主之。

下利证可概括为虚寒、实热、郁滞三种。属于虚寒的，应宜温阳散寒，或回阳救逆。如四逆汤，治阴盛格阳呕吐，下利证；通脉四逆汤，治阴盛格阳，里寒外热之下利证；诃梨勒散，治气虚不固的气利证；桃花汤，治脾胃之寒，下利不禁的便脓血证。属于实热的，以清热止利为

主。如热利下重，便脓血者，可用白头翁汤；下利后，余热不尽，而更烦者，可用栀子豉汤。属于实热积滞下利，宜用通腑泄热之法，如大、小承气汤类。

疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八

概说

本篇是论述疮痈、肠痈、金疮、浸淫疮等疾患的辨证论治。篇中共有条文八条，载方六首。其中第一、二条是论疮痈的脉证，以及疮痈鉴别诊断的方法。第三、四条是论肠痈的脉证，治法和方药。第五、六条是论金疮的脉证与发病机理和方证。第七、八条则论浸淫疮的转归和治法。由于疮痈、肠痈、金疮、浸淫疮均属外科疾患，故合为一篇论述。

疮痈，即痈肿，证候以焮红肿痛为其特点。是因火毒外结，属阳属实，蒸腐血肉，而成痈脓，其病在外，故称疮痈；若痈脓之毒热结于肠内的，则称为肠痈，一名内痈。

浸淫疮，是因湿热之毒，郁于心肺二经，向外发于皮下，形如粟米，瘙痒不止，破则流黄水，浸淫之处，无不破烂，遍于全身，故称浸淫疮。

金疮，是指肌肉被刀斧等器械所伤，亦有伤后复感毒邪，溃烂成疮，则称为金疮。

1.诸浮数脉，应当发热，而反洒淅恶寒，若有痛处，当发其痈。

【诠解】

本条是论述疮痈将发的脉证。由于湿热火毒，结聚在里，邪热外蒸，荣卫并热，故脉来浮数。若邪热遏于卫，卫气不能畅行，故见洒淅恶寒。湿热火毒，聚于一处，则必蒸腐血肉，故营血瘀腐不通，则成痈。痈毒腐化气血则为脓，是为痈脓之证，故曰：当发其痈。如此可知，脉浮数而恶寒，若无固定痛处的，则为外感；若有一定痛处的，则是痈脓病的先发之征。

【选注】

《金匱要略心典》：“浮数脉，皆阳也；阳当发热，而反洒淅恶寒者，卫气有所遏而不出也。夫卫主行营气者也，而营过实者，反能阻遏

其卫；若有痛处，则营之实者已兆，故曰当发其痈。”

2.师曰：诸痈肿欲知有脓、无脓，以手掩肿上热者，为有脓；不热者，为无脓。

【诠解】

本条论述通过触诊辨别痈肿有脓无脓的方法。由于营血凝滞，卫气不行，郁结一处，瘀而生热，热胜则腐其血肉，血肉腐败则为脓肿，故以手掩其肿上既热且软，是为有脓。假如郁滞不重，尚未化热，仅是痈肿，故按之不热而且硬，是为无脓之证。

【选注】

《金匱要略心典》：“痈肿之候，脓不成，则毒不化；而毒不聚，则脓必不成。故以手掩其肿上，热者毒已聚，则有脓；不热者毒不聚，则无脓也。”

3.肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为肠内有痈脓，薏苡附子败酱散主之。

薏苡附子败酱散方

薏苡仁十分 附子二分 败酱五分

上三味，杵为末，取方寸匕，以水二升，煎减半，顿服，小便当下。

【诠解】

本条是论述痈脓已成的证治。由于毒火聚于肠内，而发为肠痈，其身虽无热，而其脉则反数；血气凝滞于里，不得外荣肌肤，故身如鳞甲交错。痈成于内，血涩不流，则气亦滞，遂使腹皮如肿，按之仍软。虽其患在肠胃间，究非腹内有积聚，所以本证与腹内有癥瘕积聚者不同。

治以薏苡附子败酱散，排脓消痈，通阳行阴。方中薏苡仁泄热除湿，排脓利尿；败酱草清热解毒，破瘀排脓；附子辛温，扶阳而行气血津液，故能散结消肿。方后注云“顿服，小便当下”，是指服药之后，小便下者，气化则通，气化通则痈肿郁结可开，热毒瘀滞可行，大便泻出污秽之脓血，肠痈渐愈。顿服者，取其药力快捷，速下湿热火毒之意。

【选注】

《金匱要略论注》：“此论肠痈，乃肠胃之病，似宜只腹痛而不及外，不知痈乃血脉间病。肠为阳明，阳明主一身肌肉，故必其身甲错。腹为肠之府，故腹皮急，热毒之气上鼓也。气非有形，故按之濡。然皮之急虽如肿状，而实无积聚也。病不在表，故身无热，热虽无而脉数，痈为血病，脉主血也，故曰此为肠痈。薏苡寒能除热，兼下气胜湿，利肠胃，破毒肿，故以为君。败酱善排脓破血，利结热毒气，故以为臣。附子导热行结，故为反佐。”

【病案举例】

张某，男，23岁。1965年10月20日初诊。腹痛一天，发热呕吐，继则腹痛转入右下腹，经西医诊断为急性化脓性阑尾炎。先后用抗生素等药物治疗，疼痛持续不解，且发热呕吐。患者不愿手术而求治于周师。证见面色青黄，神色困惫，右少腹持续疼痛，阵发性加剧，有明显压痛、反跳痛及肌紧张，包块如掌大，畏寒发热，剧痛时四肢冰冷，舌黄有津，脉滑数。体温38.7℃，白细胞20000/立方毫米。此属寒湿郁结化热，治宜温阳祛湿清热。方用：薏米90克，炮附子30克（先煎），败酱草30克。嘱其浓煎频服。4剂后疼痛大减，呕吐止，体温正常，血白细胞总数下降为13000/立方毫米。续服上方6剂，血白细胞总数10000/立方毫米，仅右腹下包块不消。再服上方20余剂，包块消失而愈。

（摘自《上海中医药杂志》1982,5:5）

4.肠痈者，少腹肿痞，按之即痛，如淋，小便自调，时时发热，自汗出，复恶寒。其脉迟紧者，脓未成，可下之，当有血；脉洪数者，脓已成，不可下也，大黄牡丹汤主之。

大黄牡丹汤方

大黄四两 牡丹一两 桃仁五十个 瓜子半升 芒硝三合

上五味，以水六升，煮取一升，去滓，内芒硝，再煎沸，顿服之，有脓当下，如无脓，当下血。

【论解】

本条是论述肠痈脓未成的证治。火毒邪气，郁于肠内，虽聚而成形，然尚未腐肉化脓，故见少腹肿痞。肿痞瘀阻逼及膀胱，故按之即痛如淋，而实非淋，故小便自调。由于毒邪内聚，营卫之气与之相争，故时时发热，自汗出，复恶寒。血热郁滞，结实不通，束敛血脉，故脉迟

而紧。此为热伏血瘀，痈脓未成，故可下夺，令其消散。若脉不迟紧，而反洪数的，则热势已成，荣气腐而为脓，故不可下。据临床观察，此证下之似亦无害。

治以大黄牡丹皮汤，泄热逐瘀为主。方中大黄、丹皮、桃仁泄热逐瘀，排除恶血，消散痈肿；瓜子与芒硝，荡积排脓，推陈致新。方后注曰“顿服之，有脓当下，如无脓，当下血”，说明肠痈不论有脓无脓，凡属实热证者，皆可用荡热行瘀法，使瘀热脓血随大便而去，肠痈可愈。

若邪毒腐肉化脓，毒热之气弥漫不收，正气被伤，故脉洪数。治宜清热解毒，排脓消肿。然慎用攻下之法，以防更伤正气。

薏苡附子败酱散与大黄牡丹汤均治肠痈。前者适用于脓已成，正气亦伤，里热不盛者；后者适用于脓未成，热实毒盛之证。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“肠痈而少腹不可按，阳邪下结，部位牵引也。按之如淋，形容痛状，情所必至。夫血病而气不病，故小便自调，然阳邪已盛，卫气斯虚，遂发热汗出而畏寒也，痈证如是。治之者，须以脓成未成为异。欲知之法，舍脉无由，脉迟紧知热未为血瘀于内，勿使成脓，下之须早，非桃仁承气汤乎？脉若洪数者，则已成矣，岂复有瘀可下，此大黄丹皮以涤热排脓，势所必用也。”

【病案举例1】

娄某，男性，20岁。于1977年9月8日就诊。转移性右下腹痛2天。有压痛和反跳痛，恶心，口干，便秘，腰大肌试验阳性，右下腹阑尾穴压痛，舌苔薄黄，脉弦数，体温37.3℃，白细胞12000/立方毫米，中性79%。诊断：肠痈（急性阑尾炎）。服大黄牡丹皮汤加减：生大黄12克，粉丹皮、桃仁、冬瓜仁、木香、枳壳各9克，金银花、红藤、蒲公英各30克，芒硝、生甘草各6克。当日取药2剂。煎后分四次服，药后腹泻三次，腹痛减轻，以后原方去芒硝，改每日一剂，连服六剂症状消失。

（摘自《山东中医学院学报》1980,3:14）

【病案举例2】

徐某，男，44岁。自诉因做痔疮手术后，遗有腹痛。曾进行灌肠治疗，检查左侧降结肠处有一条索状物，上抵于胁，胀痛不堪，不能饮食，且大便下痢脓液、烂肉样物。每日大便五六次，有里急后重。脉弦而滑，舌苔黄腻。

辨证：肝胆热邪，迫及于肠，伤及气血，挟有瘀滞，因而形成此

证。

治法：通因通用，泻肠中之瘀，消凝结之滞，方用大黄牡丹皮汤。

处方：大黄12克，桃仁12克，冬瓜仁30克，败酱15克，鸡血藤30克，双花15克，海藻15克，佛手15克，柴胡12克，枳实10克。

服药后泻下秽浊粪便甚多，服至三剂而基本全瘳。

（刘渡舟治验）

5.问曰：寸口脉浮微而涩，法当亡血，若汗出，设不汗者云何？

答曰：若身有疮，被刀斧所伤，亡血故也。

【论解】

本条论述金疮出血的脉证。由于吐血、咯血、自汗、盗汗、遗精等原因，引起阴血亏少，血不流利，故脉则涩。阴血虚而阳气外浮，故又脉浮而微，如法当亡血或汗出伤荣。如不亡血，亦不汗出则为何故？此因若身有疮，或被刀斧所伤，亡失荣血的缘故。

【选注】

《金匱要略心典》：“血与汗，皆阴也；阴亡，则血流不行，而气亦无辅，故脉浮微而涩也。《经》云：夺血者无汗，夺汗者无血。兹不汗出而身有疮，则知其被刀斧所伤而亡其血，与汗出不止者，迹虽异而理则同也。”

6.病金疮，王不留行散主之。

王不留行散方

王不留行十分 八月八日采 蒴藋细叶十分 七月七日采 桑东南根白皮十分
分 三月三日采 甘草十八分 川椒三分，除目及闭口，去汗 黄芩二分 干姜二
分 芍药二分 厚朴二分

上九味，桑根皮以上三味烧灰存性，勿令灰过，各别杵筛，合治之为散，服方寸匕，小疮即粉之，大疮但服之，产后亦可服。如风寒，桑东根勿取之，前三物皆阴干百日。

【论解】

本条是论金疮的治疗方法。金疮是刀斧等金属器械所伤的伤科疾患，由于刀斧创伤，经脉皮肉筋骨断裂，营卫气血不能接续，伤口疼

痛，甚至气血溃烂而成疮疡。

治以王不留行散，续绝脉，愈伤口，活血行气，化瘀止痛。方中王不留行活血祛瘀，止血定痛为君药；佐以蒴藋细叶行血通经，消瘀化滞；桑根白皮续绝脉而愈伤口。以上三味烧灰存性，取灰能止血之意。姜、椒、厚朴行气破滞，温通血脉；黄芩、芍药清血热，敛血阴；重用甘草补中生肌，调和诸药，配黄芩清热解毒。本方寒热相合，气血兼顾，既可外敷，亦可内服。内外并用，畅行气血，调和阴阳，生肌长肉。“小疮即粉之”，说明肌肤损伤较轻者，外敷即可，无须内服。“大疮但服之”，由于损伤较重，应治内而安外，故需内服，或内外并用。“产后亦可服”，乃取其散瘀止血，行气活络之功。外感风寒者，去桑根白皮，防其引邪内入也。“前三物皆阴干百日”，是指王不留行、蒴藋细叶、桑根白皮。三药不宜曝晒火炙，是存其寒凉之药性之意。

【选注】

《金匱要略心典》：“金疮，金刃所伤而成疮者，经脉斩绝，营卫沮弛；治之者必使经脉复行，营卫相贯而后已。王不留行散，则行气血和阴阳之良剂也。”

7.排脓散方

枳实十六枚 芍药六分 桔梗二分

上三味，杵为散，取鸡子黄一枚，以药散与鸡黄相等，揉和令相得，饮和服之，日一服。

排脓汤方

甘草二两 桔梗三两 生姜一两 大枣十枚

上四味，以水三升，煮取一升，温服五合，日再服。

【诠解】

以上二方是论疮痈脓已成，正气伤的治法。由于火毒发炎，聚郁一处，气血不畅，热郁血瘀，蒸腐血肉化脓，而伤正气。若阴分伤的，治以排脓散，滋阴活血，行气排脓。方中鸡子黄、芍药滋阴养血，凉血解毒，活血散瘀；枳实、桔梗一升一降，开气行滞，俾大气一转，郁结乃散。诸药相合，可养阴护正，使痈脓外出，热毒可解。若正气伤的，治以排脓汤。方中甘草调中排脓，清热解毒；桔梗开提肺气，大气自转，

郁结可散；生姜、大枣辛甘为阳，调和荣卫，扶正达邪。诸药相配，以奏排脓解毒，调中祛邪之功。如此可知，排脓散治痈脓伤血分；排脓汤治痈脓伤气分。但两方均能调其升降之机，消其久瘀之痈，可以概治痈肿日久而毒不能散的病证。

【选注】

《金匱要略编注》：“肠痈必起于邪壅气血而成，壅气为热，蒸腐血肉成脓，故以鸡子黄、芍药专补阴血之正，桔梗开提肺气而下行，枳实以宣肠胃气结。俾气利则脓成毒化，故为排脓散也。”

“肠痈乃属大小肠受病，故用甘、桔善走手足阳明，开提诸气而宣行解毒，以姜、枣通调营卫而排血为脓。盖此二方，专治躯壳之内肠胃之痈而设。”

8.浸淫疮，从口流向四支者，可治；从四支流来入口者，不可治。

【论解】

本条论述浸淫疮的预后。浸淫疮是由湿热火毒客于肌肤，先痒后痛，搔破流水，浸渍皮肤，淫于全身。若浸淫疮，从四肢流向心口，这是皮肤热毒，经血脉内传于心的反映。病邪由外向内，由轻变重，故为难治。若浸淫疮从口流向四肢，为心经热毒，流散皮肤，病势向外，由重变轻，故为可治。

【选注】

《医宗金鉴》：“浸淫疮者，浸谓浸渍，淫谓不已，谓此疮浸淫留连不已也。从口流向四肢者轻，以从内走外也，故曰可治；从四肢流走入口者重，以从外走内也，故曰不可治。”

9.浸淫疮，黄连粉主之。方未见。

【论解】

本条是论浸淫疮的治法。浸淫疮是热毒在心脉、皮肤之病，治以黄连粉方，清热解毒。方中黄连苦寒入心，不论内服外敷，均有清解热毒，凉血燥湿之功。

据临床观察，用黄连、炉甘石等分研细末，麻油调敷，治黄水疮有良效。

【选注】

《金匱要略浅注》：“黄连粉方未见，疑即黄连一味，为粉外敷

之，甚者亦可内服之。诸疮痛痒，皆属心火。黄连苦寒泻心火，所以主之。”

结语

本篇论述了疮痈、肠痈、浸淫疮、金疮的病因、病机，以及治疗方法。薏苡附子败酱散，排脓消肿，振阳消阴，可治肠痈之脓已成，而正气损伤者；大黄牡丹皮汤，泄热逐瘀，可治肠痈之实热；排脓散可治痈肿兼有阴伤之象；排脓汤可治痈脓兼有气伤之征。王不留行散，活血行气，止血定痛，故能治金疮。黄连粉方，清热燥湿，凉血解毒，适用于浸淫疮。

跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九

概说

本篇是论述跌蹶、手指臂肿，转筋、阴狐疝、蛔虫等病的辨证论治。篇中共有条文八条，载方五首。其中第一条至第四条是论跌蹶、手指臂肿，转筋、阴狐疝的证候和方药。第五条至第八条是论蛔虫病的脉证、发病机理及治疗方法。本篇以蛔虫病作重点，其他各证较为简略，而这五种病证，皆与足厥阴肝和筋的病变有联系，所以，合为一篇讨论。

“跌蹶”又名“跌蹶”，似指跌倒伤足而使人只能向前行，而不能往后退。

“手指臂肿”，是指手指与手臂肿动之证。

“转筋”，是指臂、脚强直，不能屈伸。

“阴狐疝”，是指阴囊偏大偏小，时上时下，或有胀痛，重坠之感。

蛔厥，是由脏寒，蛔动不安，上扰胸膈，引起烦躁不安，呕吐蛔虫，心腹剧痛，呕吐涎沫，手足厥冷之证。

1.师曰：病跌蹶，其人但能前，不能却，刺腓入二寸，此太阳经伤也。

【词解】

跌蹶：跌，足背；蹶，颠仆，或挫折。“跌蹶”可能是因跌倒、颠仆，而伤了足太阳经脉的病症。

腓：指腓肠肌，即小腿肚。

【诠解】

本条论述“跌蹶”的病因、症状与治法。师曰：得病因跌蹶而使人但

能前行，不能后却。人身经络，阳明行身之前，太阳行身之后，今因“蹶”而伤太阳经气，故出现能前不能后的病变。治法用针刺腓，深二寸，便能自愈。因太阳之经下贯腓内，腓又是阳明经络之所过，乃是太阳阳明交会之处。故刺之以和两经之气血。

【选注】

《金匱要略论注》：“人身阳明脉络在前，太阳脉络在后，故阳明气旺无病，则能前步，太阳气旺无病，则能后移；今倾跌之后致蹶而不能如平人，能前步不能后却，必须刺腓肠入二寸者。盖腓肠者，太阳脉之所过，邪聚于太阳脉之合阳承筋间，故必刺而泻之，谓伤止在太阳经也。然太阳经甚多，而必刺腓肠者，盖腓肠即小腿肚，本属阳明，太阳脉过此，故刺之使太阳与阳明之气相通，则前后如意耳。”

2.病人常以手指臂肿动，此人身体**瞤瞤**者，藜芦甘草汤主之。

藜芦甘草汤方未见

【诠解】

本条论述风痰阻络，而成手指臂肿动之证。本病因痰湿凝滞关节则肿，风邪袭伤经络则手指臂动。风痰阻滞经络，阳气起而驱邪，风痰欲去不去，故身体**瞤瞤**而动。

治以藜芦甘草汤。方佚，想是涌吐风痰之剂。是因势利导、涌吐膈上风痰之法。藜芦涌吐风痰，升举阳气；甘草能解藜芦之毒，而和中养胃。此方使风痰消除，肺中气机畅通，则诸证可愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“湿痰凝滞关节则肿，风邪袭伤经络则动，手指臂肿动，身体**瞤瞤**者，风痰在膈，攻走肢体；陈无择所谓痰涎留在胸膈上下，变生诸病，手足项背，牵引钩痛，走易不定者是也。藜芦吐上膈风痰，甘草亦能取吐，方未见，然大略是涌剂耳。”

3.转筋之为病，其人臂脚直，脉上下行，微弦，转筋入腹者，鸡屎白散主之。

鸡屎白散方

鸡屎白

上一味，为散，取方寸匕，以水六合，和温服。

【诠解】

本条论述转筋的证治。由于湿浊化热动风，热伤阴血，筋脉失养，拘急强直，故其人臂、脚强直，其脉则长直而上下行，微弦。若转筋甚则痛不能忍而入腹，从两足牵引少腹拘急而剧痛，此为肝邪直攻脾脏。

治以鸡屎白散，清热利湿祛风。方中鸡屎白咸寒泄热，通利小便，利湿祛风，使邪气从下而去，则经络气血通畅，筋脉得润，而转筋自愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“肝主筋，上应风气；肝病生风，则为转筋。其人臂、脚直，脉上下行，微弦。《经》云：诸暴强直，皆属于风也。转筋入腹者，脾土虚而肝木乘之也。鸡为木畜，其屎反利脾气，故取治是病；且以类相求，则尤易入也。”

4.阴狐疝气者，偏有小大，时时上下，蜘蛛散主之。

蜘蛛散方

蜘蛛十四枚，熬焦 桂枝半两

上二味，为散，取八分一匕，饮和服，日再服，蜜丸亦可。

【诠解】

本条论述阴狐疝气的证治。阴狐疝气之证，是因风寒侵袭厥阴肝经所致，故其睾丸或偏左，或偏右而有大小，病发时则坠而下，病息时则收而上，故发时、息时而有上下之变。此证重时则阴囊牵引少腹剧痛。

治以蜘蛛散，温散风寒，通利血气。方中蜘蛛，捷于破结通利，去风下气，消散肝经之邪；桂枝辛温，以温散厥阴风寒之邪。风寒散则经脉畅利，诸证可解。方后注云“蜜丸亦可”，以急则用散、缓则用丸之意欤？

【选注】

《医宗金鉴》：“偏有大小，谓睾丸左右有大小也。时时上下，谓睾丸入腹，时出时入也。疝，厥阴之病也，以与狐情状相类，故名之

也。主之蜘蛛散，入肝以治少腹拘急而痛也。”

【病案举例】

彭某，男，8岁。社员。

主诉：患阴狐疝已有六年。阴囊肿大如小鸡蛋，其色不红，肿物时而偏左，时而偏右，患儿夜卧时肿物入于少腹，至白昼活动时肿物坠入阴囊，而且肿物时有疼痛感觉，几年来曾服一般疏肝解郁、利气止痛等治疝气之药，但肿物依然出没无定，未见效果。患儿平素健康，饮食二便如常，余无所苦，舌苔不黄，舌质不红，脉象弦缓。

诊断：寒气凝结肝经之阴狐疝。

治则：辛温通利，破结止痛。

方药：《金匱要略》蜘蛛散原方。

大黑蜘蛛（宜选用屋檐上牵大蜘蛛网之大黑蜘蛛，每枚约为大拇指头大小，去其头足，若误用花蜘蛛则恐中毒）六枚（置磁瓦上焙黄干燥为末），桂枝三钱。

上两味共为散，每天用水酒一小杯一次冲服一钱，连服七天。

效果：服药三天后疼痛缓解，七天后阴囊肿大及疼痛消失，阴狐疝痊愈，观察一年未见复发，患者至今仍健在。

（摘自《成都中医学院学报》1981,2:18）

5.问曰：病腹痛有虫，其脉何以别之？师曰：腹中痛，其脉当沉，若弦反洪大，故有蚘虫。

【诠解】

本条用宾主对比手法，论述蛔虫腹痛的脉证特点。问曰：“病腹痛有虫，其脉何以别之？”答曰：腹中痛而因于寒邪侵袭脾气所引起，其脉则当沉，或见弦；若腹痛因蛔虫扰动所引起，则脉必不沉不弦。而反见洪大之脉，乃是蛔虫扰动气血，热气外浮之象。同时伴有腹痛时作时止，恶心呕吐，吐涎沫，面生白色虫斑，睡中齧齿，欲食不化，大便失调，鼻孔奇痒等证。

【选注】

《金匱要略心典》：“腹痛脉多伏，阳气内闭也；或弦者，邪气入中也。若反洪大，则非正气与外邪为病，乃蚘动而气厥也，然必兼有吐涎、心痛等证，如下条所云，乃无疑耳。”

6.蚘虫之为病，令人吐涎，心痛发作有时，毒药不止，甘草粉蜜

汤主之。

甘草粉蜜汤方

甘草二两 粉一两重 蜜四两

上三味，以水三升，先煮甘草取二升，去滓，内粉蜜，搅令和，煎如薄粥，温服一升，差即止。

【词解】

毒药不止：《本草经》将药物分成上、中、下三品，下品多毒。毒药不止，是指用过多种驱虫毒药，不能制止。

【诠解】

本条论述蛔虫病的证治。蛔虫寄生于肠，动扰不安，若上扰于胃，则廉泉开放，故令人吐涎；蛔动则痛，蛔下则止，所以心痛发作有时。此证若用毒药折之，则与虫相恶，而虫不受，故曰“毒药不止”。

治以甘草粉蜜汤，乃是用甘味药投虫所好于先，继之铅粉杀虫于后。况甘草、白蜜又有养胃和中，缓急止痛，以防铅粉之毒。铅粉毒性甚剧，不宜多服，故方后注云“差即止”。

本方中的粉，有的注家认为是“米粉”。其味甘，性平，有和胃、解毒、缓急的作用。因服杀虫药后，吐涎腹痛不止，胃中不和，胃气已伤，故用米粉，养胃和中，安蛔止痛，待正气恢复，病情缓和，然后再用杀虫药，其说供参考。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“夫饮食入胃，胃中有热则虫动，虫动则胃缓，胃缓则廉泉开，故吐涎。虵上入膈故心痛，虵闻食臭出，得饮则安，故发作有时也。毒药不止者，虵恶之不食也。虵喜甘，故用甘草蜜之甘，随所欲而攻之，胡粉甘寒，主杀三虫，虵得甘则头向上而喜食，食之即死，此反佐以取之也。”

【病案举例】

王氏妇，年20余，素有蛔虫病史，1943年仲夏，旧恙复发，脘腹耕痛，呕吐不纳，辗转反侧，坐卧不宁。自服山道年药片无效，嘱余诊视。以驱虫理气之剂，数服不应，患者固请别筹良法，因忆《金匱要略》有甘草粉蜜汤方，主治蛔虫病吐涎心痛，发作有时，毒药不止者，

曷与试之。遂用：生甘草15克，煎汤去滓，加入铅粉5克，白蜜30毫升拌匀，煎如薄粥状，分二次温药，初期稍安，再服痛呕渐止，次日大便排出蛔虫二十余条，从此痊愈。

（摘自《浙江中医学院学报》1981,2:14）

7.蚘厥者，当吐蚘，令病者静而复时烦，此为藏寒，蚘上入膈，故烦；须臾复止，得食而呕，又烦者，蚘闻食臭出，其人当自吐蚘。

【词解】

藏寒：即脏寒，指肠有寒。

【论解】

本条论述蛔厥的病机。本证是因肠寒胃热，蛔虫避寒就温，窜扰于胃，或钻入胆道，故曰：蛔上入膈。蛔虫因寒而动，胃受蛔扰，故复时烦；若蛔得温则安，故病者安静。如得饮食，蛔闻食臭，出而扰动，故得食则呕，又烦，而呕吐蛔虫。由于脏寒蛔动，腹痛时作，寒热错杂，阴阳之气不相顺接，故手足厥冷。所以，此证亦名蛔厥。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“蚘厥者，病蚘而手足厥冷也。蚘厥者当吐蚘，病者静而复时烦，此因肝脏寒而蚘上入膈，故烦。盖言蚘生于肝，因脏寒而上入于膈也。须臾复止，得食而呕，又烦者，此蚘闻食臭而出于胃，故其人常自吐蚘。盖言蚘因风而生于肝，脏寒则上入膈，闻食臭则出于胃也。”

8.蚘厥者，乌梅丸主之。

乌梅丸方

乌梅三百个 细辛六两 干姜十两 黄连一斤 当归四两 附子六两，
炮 川椒四两，去汗 桂枝六两 人参 黄蘗各六两

上十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五升米下，饭熟捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧子大，先食饮服十丸，日三服，稍加至二十丸。禁生、冷、滑、臭等食。

【论解】

本条是论蛔厥的治法。蛔厥是由脏寒蛔动，上入于膈所致的寒热错杂证。

治以乌梅丸，安蛔止厥，调和肝胃。方中乌梅酸温，养肝安胃，蛔得酸则止；附子、干姜、桂枝、川椒、细辛味辣性热，能通阳破阴，并有杀虫作用；黄连、黄柏苦寒清泻心胃之热，以止呕烦，且能驱蛔下行；人参、当归补养气血，以扶正气之虚。本方寒热并用，使脏寒得温，胃热得降，气血调和，脏安蛔下，诸证可解。

【选注】

《医宗金鉴》：“李彰曰：乌梅味酸，黄连、黄柏味苦，桂枝、蜀椒、干姜、细辛味辛，以蛔得酸则止，得苦则安，得甘则动于上，得辛则伏于下也。然胃气虚寒，人参、附子以温补之，吐亡津液，当归以辛润之，则蛔厥可愈矣。”

【病案举例】

黄某，女，13岁。1979年5月10日早饭后突然右上腹部阵发性绞痛，如刀割样，坐卧不安，伴恶心呕吐，吐出物初为食物残渣，后为胆汁，吐出蛔虫2条，经大队卫生所治疗未愈。即日下午4时30分入院。诊见神志清楚，急性病容，弯腰捧腹，痛苦呻吟，坐卧不安，体温36.5℃，腹部平坦，右上腹部有深压痛，腹肌稍为紧张，肠鸣音正常。舌质淡红，舌苔薄白，脉弦。既往无胃痛史。诊断：胆道蛔虫症。治疗：入院后即给予乌梅丸加味。

乌梅120克，川连10克，黄柏10克，附子6克，干姜6克，细辛3克，桂枝10克，党参10克，当归10克，川椒6克，槟榔30克，使君子15克，苦楝皮15克，榧子15克，木香10克。1剂水煎频服，当夜8时左右患者疼痛停止，安静入睡，次日下午大便排出蛔虫10多条，留医2天痊愈出院。

（摘自《广西中医药》1981,3:47）

结语

本篇论述了跌蹶、手指臂肿、转筋、阴狐疝、蛔虫等病证、病机，以及方药。

跌蹶病，则用针刺腠部，使气血畅通而病解。手指臂肿因风痰致病，用藜芦甘草汤，涌吐风痰而愈。转筋由风热挟湿为病，用鸡屎白散，利湿清热祛风。阴狐疝，则是寒湿之邪侵袭肝经，故用蜘蛛散，辛温通利，以解其邪。蛔虫病，为心痛吐涎，发作有时，毒药不止者，可

用甘草粉蜜汤，投其所好，诱杀蛔虫；至于蛔厥证者，则用乌梅丸，调和阴阳，安胃驱虫。

妇人妊娠病脉证并治第二十

概说

本篇是论述妇人妊娠期内一般疾病的辨证论治。内容有妊娠恶阻，妊娠宿有癥病、腹痛、下血、小便难、水气病以及安胎养胎的方法。篇中共有条文十一条，载方九首。其中第一、二条是论妊娠的脉证，妊娠有癥病的脉证和方药。第三、四、五条是论妊娠腹痛，或腹痛下血并见的证候与治法。第六条则论妊娠呕吐的方证。第七、八条是论妊娠小便难的辨证和方药。第九、十、十一条是论妊娠安胎养胎的方药，以及伤胎的治法。

本篇的重点，是论妊娠期内的腹痛和下血。因为妊娠腹痛、下血，均能导致流产，并能影响胎儿的发育。所以，在这方面的论述亦比较具体。

1.师曰：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之方见利中。于法六十日当有此证，设有医治逆者，却一月，加吐下者，则绝之。

【词解】

绝之：禁绝医药之意。

【诠解】

本条是论述妊娠恶阻的辨证论治。妊娠恶阻，大都在妊娠六十日左右出现。此时胎元初结，经血归胞养胎，胎气未盛，阴血不足，则尺脉小弱，其人口渴。阴血不足，胎热上逆，则不能饮食而恶心呕吐。寸关脉象平和，身无寒热，知无他病，是妊娠反应，为恶阻现象。

治以桂枝汤滋阴和阳，调和营卫。方中桂枝调阳气；芍药养阴血；生姜、大枣、甘草调和脾胃，滋生气血。

如妇女在断经初期，医生不知是怀孕，认为是经闭不行而误治，在断经一个月，就可出现此证，如更加上吐下泻的，则应当停止服药，细

心观察病情变化，以免发生问题。

【选注】

《金匱悬解》：“妇人得和平之脉，而尺脉小弱，其人渴不能食，外无寒热表证，是名妊娠。《难经》：命门者，诸精神之所舍，元气之所系也。男子以藏精，女子以系胞。盖子宫者，少阴肾之位也，故脉见于尺。胎之初结，气血凝塞，不见流溢，故脉形小弱。胎妊方成，中气塞满，胃逆不降，故恶心呕吐，不能甘食；胃逆则金火皆升，是以发渴。桂枝汤甘草、大枣补其脾精，桂枝、芍药调其肝血，生姜降逆止呕，妊娠初治之良法也。于妊娠之法，六十日间当有此证，设有医治之逆者，却一月之内而见此证，加以吐下，此中气之败，不关胎故，则调燮中气，绝其病本也。”

2.妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥瘕害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衃也。所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥，桂枝茯苓丸主之。

桂枝茯苓丸方

桂枝 茯苓 牡丹去心 桃仁去皮尖，熬 芍药各等分

上五味，末之，炼蜜和丸如兔屎大，每日食前服一丸，不知，加至三丸。

【词解】

衃：血凝不散。

【诠解】

本条是论述妊娠宿有癥病的辨证论治。妇人本有癥病，月经照常来潮，现在经停受孕成胎，经断未到三个月，由于癥病阻于血脉，血不循常道，则漏下不止。癥瘕阻碍血脉运行，则脐上跳动不安。虽病在血分，亦属胎动。因瘀而漏下，故癥积不去，则漏下不会停止，只有下去癥积，血脉正常运行，方可安胎。

治以桂枝茯苓丸，祛瘀化癥。方中桂枝温通血脉；芍药凉血活血；桃仁、丹皮活血化瘀；茯苓健脾以化湿浊，俾血利气畅则瘀消而癥行。然每日食前服一丸，亦慎之至也。

文中“妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也”说明正常的妊娠胎动。经停六个月有胎动，停经前三个月，经水是正常通利的，此时胎动，则知是妊娠而非病也。

文中“下血者，后断三月衄也”说明辨明癥积的依据。停经前三个月，月经就不正常，然后停经三个月，又漏下紫黑的瘀血，如兼见小腹跳动，则是癥积而非妊娠是没有疑问的了。

【选注】

《金匱要略心典》：“癥，旧血所积，为宿病也。癥瘕害者，宿病之气，害其胎气也。于法妊娠六月，其胎当动，今未三月，胎不当动而忽动者，特以癥瘕害之之故。是六月动者胎之常，三月动者胎之变也。夫癥病之人，其经月当不利，经不利，则不能受胎；兹前三月经水适利，胞宫净而胎可结矣。胎结故经断不复下，乃未三月而衄血仍下，亦以癥瘕害之之故，是血留养胎者其常，血下不止者其变也。要之，其癥不去，则血必不守，血不守则胎终不安，故曰当下其癥。桂枝茯苓丸下癥之力颇轻且缓，盖恐峻厉之药，将并伤其胎气也。”

【病案举例】

张某，女，38岁，社员，于1978年3月10日就诊。

月经已闭止3个月，午后发烧，食欲减。诊见：形体枯槁，腹部按痛，曾经他医诊为血虚胃弱，血亏经闭，治以养血健胃舒肝之品，屡治罔效，病势渐重。且腹部膨隆显著，似妊娠五六月状，按之坚硬如石，推之不移，痛当少腹，诊其脉沉滑有力，右关更属明显，舌紫有瘀点。余曰：此胎兼癥瘕也，恐有半产之虞。遵仲景桂枝茯苓丸方意，处以：桂枝15克，丹皮15克，芍药20克，桃仁15克，二剂，水煎服。服后，病情如故。再诊，于前方将桂枝增至25克，桃仁增至20克，再投二剂。服后，腹内雷鸣，翌晨大便二次，便色紫黑且硬，腹痛稍减。三诊：积块坚硬，固定不移，拒按，皮肤不润，舌边紫，苔厚而干，脉沉涩。又投原方二剂，丹皮增至35克。服后，下血盈盆，家人大惊。自此腹部膨隆消失，按之柔软，不再疼痛，食欲渐佳。但细扪脐下，仍有似鹅卵大一枚悸动。余曰此胎气也。调理渐安，至足月顺产一女婴。

（摘自《吉林中医药》1981,1:38）

3.妇人怀娠六七月，脉弦发热，其胎愈胀，腹痛恶寒者，少腹如扇，所以然者，子藏开故也，当以附子汤温其藏。方未见。

【词解】

少腹如扇：扇是动词，言少腹如扇风一样的寒凉感觉。

【论解】

本条是论述妊娠阳虚寒盛腹痛的辨证论治。妇人怀孕六七个月，脉弦发热。有似表证，其胎愈胀而痛，腹部恶寒，甚至少腹阵阵作冷，状如被扇。所以然者，子脏开而不合，而风冷之气乘之，阳虚有寒，故脉见弦。阳虚气浮，故发热。

治以附子汤，温阳散寒，暖宫安胎。方中附子温阳气，散阴寒；人参补元气，振阳光；茯苓、白术健脾生新，补气补血；芍药和血又能敛阴，制附子之燥热，敛外浮之虚阳。

【选注】

《张氏医通》：“妊娠脉弦为虚寒，虚阳散外，故发热，阴寒内逆故胎胀。腹痛恶寒者，其内无阳，子脏不能司闭藏之令，故阴中觉寒气习习如扇也。用附子汤以温其藏，则胎自安。”

【病案举例】

王某，女，35岁，经产妇。怀孕七个月，忽腹部疼痛，绵绵不休。经多方治疗，痛益甚。我诊时已月余，患者畏寒，腹部更甚，口中和，喜热饮，泛清涎，脉弦而无力。先以逍遥散加味以调气安胎，无效。不得已乃用《伤寒论》附子汤原方：附子15克，茯苓15克，党参25克，白术25克，白芍15克，连服三剂而愈。至期产一男甚壮。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,4:15）

4.师曰：妇人有漏下者；有半产后因续下血都不绝者；有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻，胶艾汤主之。

芎归胶艾汤方

一方加干姜一两。胡洽治妇人胞动无干姜。

芎^劳 阿胶 甘草各二两 艾叶 当归各三两 芍药四两 干地黄四两

上七味，以水五升，清酒三升，合煮取三升，去滓，内胶令消尽，温服一升，日三服，不差更作。

【词解】

胞阻：证候名，胞中之气血不和，而阻其生化之能。

【论解】

本条是论述妇人三种漏下的辨证论治。妇人下血，其中有三种病证：一为经水淋漓不断的漏下；一为半产后继续下血不止的漏下；一为妊娠胞阻下血的漏下。胞阻病，由于冲任脉虚寒，阻血不能内守，血液下漏，不能入胞以养胞胎，影响胞胎正常发育，故腹中作痛。妊娠下血腹中痛，称为胞阻之证。漏下和半产后下血不止的病机，也是因为冲任虚寒，阻血不能内守所致。

此三种漏下虽然不同。都可以用胶艾汤补血固经，调其冲任而愈。方中阿胶养血止血；艾叶温经暖胞；当归、川芎、地黄、白芍补血养肝，敛阴益荣，以养胞胎；甘草调和诸药，缓中解急，共奏温暖胞宫、调补冲任之效。

【选注】

《金匱要略心典》：“妇人经水淋漓及胎产前后下血不止者，皆冲任脉虚而阴气不能守也。是惟胶艾汤为能补而固之，中有芎、归，能于血中行气；艾叶利阴气，止痛安胎，故亦治妊娠胞阻。胞阻者，胞脉阻滞，血少而气不行也。”

【病案举例1】

朱某，女，25岁，1973年10月19日诊。足月异位（臀）分娩后40天，恶露不净，下腹部疼痛，纳差，舌质嫩尖红，苔薄黄，脉濡数。产后气血亏弱，胞宫瘀热未清，拟胶艾四物汤加减：炒川芎、赤芍、白芍、炒党参、焦白术、淡黄芩、川断、失笑散（包）各10克，益母草、生地、熟地、黄鱼膘胶各12克，艾绒炭3克。服五剂，恶露已止，唯腹仍微痛，食欲未振，原方加谷芽，5剂而愈。

（摘自《浙江中医杂志》1980,11-12:536）

【病案举例2】

粟某，女，32岁，教员。1979年11月25日诊。

月经一月两潮已有一年余，西医诊断为功能性子宫出血。曾服“归脾汤”、“补中益气汤”数十剂，效果不显著。此次月经来潮，量多，色淡，质稀，至今十天仍淋漓不尽，身倦无力，头昏眼花，面色萎黄，身腰畏寒，腹胀腰酸，胃纳不佳，偶有心悸，手足麻木，下肢浮肿等症，舌体稍胖，舌质浅淡，舌苔薄白，脉沉细无力。辨证为肾虚冲任不固、血海不藏之患，方用胶艾四物汤（《金匱要略》）加味：

熟地20克，白芍12克，当归12克，杜仲12克，川断15克，山萸10克，川芎3克，茯苓10克，菟丝子12克，艾叶炭10克，阿胶15克（蒸兑）。

服药5剂，药见初效，守原方15剂，身倦腰酸，头昏诸症显著减轻。12月份月经正常来潮一次，但量仍较多，三诊嘱每次月经干净后开始，服原方五剂，连续三个月。停药后观察半年，月经恢复正常。

（摘自《陕西中医》1981,1:9）

5.妇人怀娠腹中**疔**痛，当归芍药散主之。

当归芍药散方

当归三两 芍药一斤 茯苓四两 白术四两 泽泻半斤 芎^劳半斤 一作三两

上六味，杵为散，取方寸匕，酒和，日三服。

【词解】

疔痛：腹中绵绵而痛也。

【论解】

本条是论述妊娠腹痛的辨证论治。妇人妊娠肝血虚而脾湿盛，则肝脾气血不和，故腹中拘急而绵绵作痛；湿邪不化则小便不利，下肢浮肿。

治以当归芍药散，养血疏肝，健脾利湿。方中重用芍药，平肝气以安脾胃，配合当归、川芎调肝养血，以和血气；白术健脾燥湿，配合茯苓、泽泻渗湿利水，泄浊退肿。如此，则腹痛止，胎自安。

【选注】

《金匱要略论注》：“**疔**痛者，绵绵而痛，不若寒疝之绞痛，血气之刺痛也。乃正气不足，使阴得乘阳，而水气胜土，脾郁不伸，郁而求伸，土气不调，则痛绵绵矣。故以归、芍养血；苓、术扶脾，泽泻泻其有余之蓄水，芎^劳畅其欲遂之血气。不用黄芩，**疔**痛因虚，则稍挟寒也；然不用热药，原非大寒，正气充则微寒自去耳。”

【病案举例】

傅某，女，24岁，农民，1979年10月分娩一男婴，生产时出血较多，产后两月仍有阴道不规则出血，淋漓不断，色淡。伴下腹疼痛，纳呆，精神萎靡不振，面黄肌瘦。妇科检查：子宫复位不良。给当归芍药

散两剂。四天后复诊，阴道出血极少，腹痛消失，嘱服第三剂当归芍药散加党参、黄芪。药后诸证若失，半年后随访未见复发。

（摘自《湖北中医杂志》1982,2:23）

6.妊娠呕吐不止，干姜人参半夏丸主之。

干姜人参半夏丸方

干姜 人参各一两 半夏二两

上三味，末之，以生姜汁糊为丸如梧子大，饮服十丸，日三服。

【诠解】

本条是论述妊娠胃虚寒饮呕吐的辨证论治。由于脾胃虚寒，水液凝滞，蓄为痰饮，浊阴上逆，则呕吐涎沫稀水。饮停中焦，常见脘闷不食，脉弦苔滑等证。

治以干姜人参半夏丸。方中干姜温中散寒，振奋中阳；人参健脾补正；半夏降逆止呕；生姜汁蠲饮降逆。此方可使中阳得振，寒饮蠲化，胃气顺降，则呕吐自止。

【选注】

《金匱玉函经二注》：“此即后世所谓恶阻病也。先因脾胃虚弱，津液留滞，蓄为痰饮。至妊二月之后，胚化成胎，浊气上冲，中焦不胜其逆，痰饮遂涌，呕吐不已，中寒乃起。故用干姜止寒，人参补虚，半夏、生姜治痰散逆也。”

7.妊娠小便难，饮食如故，当归贝母苦参丸主之。

当归贝母苦参丸方男子加滑石半两

当归 贝母 苦参各四两

上三味，末之，炼蜜丸如小豆大，饮服三丸，加至十丸。

【诠解】

本条是论述妊娠小便难的辨证论治。妊娠小便难，饮食如故，说明病不在中焦而在下焦。由于妊娠血虚，下焦复有湿热，以致小便困难而

不爽利。

治以当归贝母苦参丸。用当归和血润燥；贝母开结解郁；苦参清热利湿。三药合作，则肝疏血利，气开湿行，而小便自利。此方用于临床有意想不到之疗效。

【选注】

《金匮要略方论本义》：“妊娠小便难，饮食如故者，血虚生热，津液伤而气化斯不利也。主之以当归贝母苦参丸，当归生血，贝母清气化之源，苦参降血热之火，又为虚热之妊娠家立一法也。”

8.妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩，葵子茯苓散主之。

葵子茯苓散方

葵子一斤 茯苓三两

上二味，杵为散，饮服方寸匕，日三服，小便利则愈。

【诠解】

本条是论述妊娠水气的辨证论治。妊娠有水气，往往由于怀孕之后，经络血脉不能畅行，气化受阻，所以小便不利。水气内停，溢于肌表，则身体浮肿而重。经络血脉不能畅行，水湿凝滞，阳气不达肌表，则洒淅恶寒。清阳不升，则头眩。辨证关键在于小便不利，切须注意。

治以葵子茯苓散通络利水。方中茯苓健脾化气，渗湿通络，利水祛湿；葵子滑窍行水，使水利湿去。葵子茯苓散使脉络畅行，水湿下利，所以小便一利，则诸证可愈。

【选注】

《金匮要略阐义》：“妊娠有水气，水为阴湿之物，一身之阳悉为所遏，如肌肉之阳不运而身重，膀胱之阳不化而小便不利，卫阳不固护而洒淅恶寒，胃阳不升而头眩。葵子茯苓散主之者，葵子滑利通阳，茯苓淡渗通阳，阴湿之水邪下泄，诸阳皆得其通。”

9.妇人妊娠，宜常服当归散主之。

当归散方

当归 黄芩 芍药 芎^劳各一斤 白术半斤

上五味，杵为散，酒饮服方寸匕，日再服。妊娠常服，即易产，胎无苦疾，产后百病悉主之。

【诠解】

本条是论述妊娠血虚而内热的养胎方法。妊娠之后，胎夺气血，肝血虚而生内热，脾气虚而生内湿，血虚与湿热交病，则症见：身体瘦弱，内热心烦，头晕胸闷，食少恶心，腹痛，胎动不安，甚至流产等证。

宜常服当归散，养血健脾，清化湿热。方中当归、芍药补肝养血，和血敛阴；川芎理血解郁，条达肝气；白术健脾化湿；黄芩清热坚阴，合奏安胎之效。

肝脾两虚之证，非几剂之功，故曰宜常服。

【选注】

《金匱要略阐义》：“妊娠血以养胎，血为胎夺，虚而生热，是其常也。‘宜常服’，谓不病亦宜常服也。当归、芍药，一动一静以养血，川芎调达肝阳，黄芩清热和阴，白术健脾胜湿，酒服方寸匕，从血分以和其肝脾也。”

【病案举例】

李某，女，27岁。婚后两年，孕三胎，均于孕后两个月左右流产，1976年7月来诊。经停40余月，微有恶心，头眩及轻微腹痛，无下血，脉濡滑而数，舌尖微红。为预防再次流产，给服当归散：当归10克，黄芩10克，炒白芍10克，川芎5克，白术10克，紫苏梗10克，青竹茹10克。服药20余剂，后足月妊娠。

（摘自《陕西中医》1981,3:44）

10.妊娠养胎，白术散主之。

白术散方见《外台》

白术 芎^劳 蜀椒三分，去汗 牡蛎

上四味，杵为散，酒服一钱匕，日三服，夜一服。但苦痛加芍药；心下毒痛倍加芎^劳；心烦吐痛不能食饮，加细辛一两、半夏大者二十

枚，服之后，更以醋浆水服之；若呕，以醋浆水服之，复不解者，小麦汁服之；已后渴者，大麦粥服之。病虽愈，服之勿置。

【词解】

醋浆水：一名酸浆水，古代饮料，有健胃清热的作用。

【诠解】

本条是论述脾虚寒湿的养胎方法。妊娠之后，胎夺气血，若肝经虚寒而血少，不能养胎，则胎动不安。脾经虚寒而生寒湿，寒湿中阻，则症见心腹时痛，呕吐清水痰涎等证。

治以白术散，温暖肝脾，除湿安胎。方中蜀椒温脾暖肝，健胃养胎；川芎舒肝和血；白术健脾化湿；牡蛎敛阴潜阳，能协蜀椒促进胃肠消化。

上证若属肝血涩少，阴血不利，腹内抑屈而苦痛者，则加芍药和其阴血；瘀血阻滞，阴血不能下达胞胎，心下毒痛者，则加川芎破瘀通络，运化胎血下行；若中焦寒湿停留，痰湿郁滞，故胸满心烦，呕吐涎沫，腹痛不能饮食，则加细辛温化寒饮，散沉寒痼冷；如呕吐气逆则加半夏健脾化痰，和胃止呕；另用酸浆水和胃止呕。若服后呕不止，改用小麦汁之甘以和胃。若呕吐已止，胃中津液不足，口渴者，则服大麦粥补脾调中，生津止渴。

【选注】

《金匱要略阐义》：“妊娠养胎，谓胎不长，当服药以养生长之机，非无故服药也。养胎之要，首重肝脾，肝为生血之源，土为万物之母，主以白术散者，川芎利肝，白术培土，蜀椒以助肝阳，牡蛎以和肝阴，肝脾阴阳调和，则生气勃然矣。”

11.妇人伤胎怀身，腹满不得小便，从腰以下重，如有水气状，怀身七月，太阴当养不养，此心气实，当刺泻劳宫及关元，小便微利则愈。见《玉函》。

【诠解】

本条是论述怀孕伤胎的辨证论治。妊娠七个月，手太阴肺经应当养胎，但是，心火气实，损伤肺阴肺气，肺不得降，既不能养胎，又不能通调水道，故胎动不安，腹满，小便不利，腰以下沉重而肿，如有水气。此证为心火气实，传于肺经，损伤胎气，故不可治肺，法当泻其心气，行其水气。心火降则肺气自行，小便通利则心气可降。用针刺劳宫以泻心气，刺关元以行水气。劳宫、关元二穴，孕妇慎用，深刺强泻可

以落堕，故针法宜浅宜轻。

【选注】

《金匱要略直解》：“七月手太阴肺经养胎，金为火乘，则肺金受伤而胎失所养，又不能通调水道，故有腹满不得小便，从腰以下有如水气状也。劳宫穴在手心，厥阴心主穴也，泻之则火不乘金矣。关元穴在脐下，为小肠之募，泻之则小便通利矣，此穴不可妄用，刺之能落胎。”

结语

本篇是论述妊娠期间疾病的辨证论治。

妊娠呕吐，有阴血不足，胃虚有热者，可用桂枝汤，调和脾胃，生长气血；有胃虚寒饮上逆者，可用干姜人参半夏丸，振奋中阳，蠲化寒饮。妊娠腹痛，有阳虚寒盛者，可用附子汤，温阳散寒，暖宫安胎。若肝脾不调者，可用当归芍药散，养血疏肝，健脾利湿。妊娠下血，有癥积漏下者，可用桂枝茯苓丸，祛瘀化癥，癥害去则其血自止。有冲任虚寒，不能摄血者，可用胶艾汤，补血固经，调其冲任。

妊娠小便不利与小便难二证，小便难多属于气郁血虚，生热化燥，可用当归贝母苦参丸，和血解郁，清热润燥。小便不利多为气化受阻，可用葵子茯苓散，化气通络利水，使小便通利，水有去路，水气自消。

妊娠养胎，有肝血虚少，脾经湿热者，可用当归散，养血健脾，清化湿热。有肝血涩少，脾经寒湿者，可用白术散，温暖肝脾，除湿安胎。养胎大法，重在调理肝脾。因为肝主藏血，血充则可以养胎，脾主化生气血，脾健则气血来源充足，从而达到养胎安胎的目的。

妇人产后病脉证治第二十一

概说

本篇论述妇人产后疾病的辨证论治。产后由于耗津失血，而有三大证：即痉病、郁冒、大便难。其次又围绕产后机体特点，论述了腹痛、中风、发热、下利等病的证治。

本篇共有条文十一条，载方九首，附方二首。篇中第一条至第三条阐述了产后痉病、郁冒、大便难的发病机理、证候，以及辨证论治和方药。第四条至第七条是论产后瘀血腹痛的脉证、辨证和方药。第八、九条则论产后中风的证候和治方。第十、十一条为产后乳中虚、下利二证的辨证和方药。

1.问曰：新产妇人有三病，一者病痉，二者病郁冒，三者大便难，何谓也？师曰：新产血虚，多汗出，喜中风，故令病痉；亡血复汗，寒多，故令郁冒；亡津液胃燥，故大便难。

【词解】

痉：即痉病。痉音厠，恶也，风病也。

【论解】

本条是论述产后痉病、郁冒、大便难的病因、病机。产后伤津亡血最易发生痉病、郁冒、大便难三种疾病。

痉病，是由于产后失血过多，营血虚少，营卫失调，腠理不固，汗出过多，容易感受风邪。阴血虚少，则不能濡养筋脉，复感风邪，则最易化燥伤筋，因而痉挛抽搐等症随之而起，形成痉病。

郁冒，是由于产后失血过多，汗出也多，阴血两虚，容易感受寒邪。寒邪外束则阳气不能外达，阴血虚少则虚阳势必上冲，因而形成郁冒。

大便难，是由于产后失血过多，汗多伤阴，阴血不足，不能濡润大肠，则见大便难。

以上三证的病机，皆为津血两虚所引起，故在治疗上，都必须以照顾津液为主。

【选注】

《金匱要略心典》：“痉，筋病也；血虚汗出，筋脉失养，风入而益其劲也。郁冒，神病也；亡阴血虚，阳气遂厥，而寒复郁之，则头眩而目瞤也。大便难者，液病也；胃藏津液而渗灌诸阳，亡津液，胃燥，则大肠失其润而便难也。三者不同，其为亡血伤津则一，故皆为产后所有之病。

2.产妇郁冒，其脉微弱，呕不能食，大便反坚，但头汗出，所以然者，血虚而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出，以血虚下厥，孤阳上出，故头汗出。所以产妇喜汗出者，亡阴血虚，阳气独盛，故当汗出，阴阳乃复。大便坚，呕不能食，小柴胡汤主之。方见呕吐中。

【诠解】

本条是论述产后郁冒与大便难同见的证治。产后失血过多，荣卫失调，腠理不固，既喜汗出，而又恐汗出过多损伤阴液，然最易感受外邪。因虚多而邪少，故其脉微弱。中虚故呕而不能食。胃肠津液干涸，故大便反坚。热不能外越，所以身无汗，而但头汗出。“所以然者”为自注句，指出血虚而阳厥，厥而必冒。冒家欲解，必大汗出，使郁阳得伸则愈，以是之故，产妇喜汗出，以其荣卫和也，故曰“阴阳乃复”，若大便坚，呕不能食，则涉及少阳之证喜呕，故可用小柴胡汤解之。

“冒家欲解，必大汗出”，反映血虚亡阴，阳气偏盛，表寒闭郁，孤阳上出之郁冒，必须全身汗出，使其阳气外达而郁解，阳气外出而不上出，所以冒家可解。

治以小柴胡汤，扶正达邪，和利枢机。方中柴胡条达少阳，使清阳之气外达，发散少阳之郁邪；黄芩清泄里热，收敛阳气；半夏、生姜和胃降逆止呕；人参、甘草、大枣扶正达邪，调补脾胃，俾上焦得通，津液得下，胃气因和，则濈然汗出而解。选用小柴胡汤和调之法，有“故当汗出，阴阳乃复”自在其中。

【选注】

《医宗金鉴》：“产妇昏冒，脉微弱者，是气血俱虚应得之诊也。不能食者，是胃气未和应得之候也。大便反坚者，是肠胃枯干应得之病也。究之郁冒所以然者，由血虚则阴虚，阴虚则阳气上厥而必冒也。冒家欲解，必大汗出者，是阳气郁得以外泄而解也，故产妇喜汗出也。由此推之，血瘀致冒，解必当血下，是阴气郁得以内输而解也。最忌者，

但头汗出，则为阴亡下厥，孤阳上出也。大便坚，呕不能食，用小柴胡汤，必其人舌有苔身无汗，形气不衰者始可，故病得解，自能食也。若有汗当减柴胡，无热当减黄芩，呕则当倍半夏、生姜，虚则当倍人参，又在临床之变通也。”

3.病解能食，七八日更发热者，此为胃实，大承气汤主之。见瘧病中。

【诠解】

本条是承上文论述郁冒之病已解，胃和能食，至七八日而又发热，然发热而不恶寒，便知其不在表而在里，又因其能食而更发热，便知非为虚而为实，因食复发热，其大便必硬，其腹亦必痛，故曰“此为胃实”，可用大承气汤攻下。

【选注】

《金匱要略编注》：“此即大便坚，呕不能食，用小柴胡汤而病解能食也。病解者，谓郁冒已解。能食者，乃余邪隐伏胃中，风热炽盛而消谷；但食入于胃，助起余邪复盛，所以七八日而更发热，故为胃实，是当荡涤胃邪为主，故用大承气峻攻胃中坚垒，俾无形之邪相随有形之滞一扫尽出，则病如失。仲景本意，发明产后气血虽虚，然有实证，即当治实，不可顾虑其虚，反致病剧也。”

4.产后腹中**疔**痛，当归生姜羊肉汤主之。并治腹中寒疝，虚劳不足。

当归生姜羊肉汤方见寒疝中

【诠解】

本条是论述产后血虚而寒客于腹的证治。产后血虚，客寒阻滞气血，则腹中**疔**痛，而又喜温喜按为其特点。

治以当归生姜羊肉汤，温中和血，养血补虚，温寒止痛。方中当归补血，温通血脉；生姜温中散寒；羊肉温补肝血。此方除治血虚受寒，腹中**疔**痛外，又可治肝血虚寒，而两目**眊眊**视物不清之证。

【选注】

《金匱要略心典》：“产后腹中**疔**痛，与妊娠腹中**疔**痛不同，彼为

血虚而湿扰于内，此为血虚而寒动于中也。当归、生姜温血散寒。孙思邈云：羊肉止痛利产妇。”

5.产后腹痛，烦满不得卧，枳实芍药散主之。

枳实芍药散方

枳实烧令黑，勿大过 芍药等分

上二味，杵为散，服方寸匕，日三服，并主痈脓，以麦粥下之。

【诠解】

本条是论述产后气血不畅，腹中作痛的证治。产后气滞血瘀，气血不畅，故而腹痛，腹满，心烦而不得卧。

治以枳实芍药散行气和血，以解除疼痛。方中枳实烧黑入血，行气去瘀，下行破结；芍药通利血脉而止疼痛。枳实、芍药两药相合，能理气调血，破积结止疼痛；用大麦粥送服，和胃气以调气血也。枳实、芍药少量小，破瘀力弱，故用于瘀血轻证为宜。本方能活血行气，故又有消散痈肿，排除脓毒的作用。

【选注】

《金匱要略编注》：“此气滞腹痛也。产后中气必虚，虚则气滞而食亦滞，故腹痛，烦满不得卧，勿疑产后定属瘀血而痛也。故以枳实破气行滞，芍药收阴而和脾养血。因产后血虚，所以用之。此剂行气和血，故主痈脓，以麦粥下之，乃和肝气而养心脾也。”

6.师曰：产妇腹痛，法当以枳实芍药散，假令不愈者，此为腹中有干血着脐下，宜下瘀血汤主之。亦主经水不利。

下瘀血汤方

大黄三两 桃仁二十枚 蟅虫二十枚，熬，去足

上三味，末之，炼蜜和为四丸，以酒一升，煎一丸，取八合，顿服之，新血下如豚肝。

【词解】

干血：血液不流，干着一处。

【诠解】

本条继上条论述枳实芍药散证，如服药而不愈，为病重药轻，内有干血，凝结于少腹，疼痛拒按。

治以下瘀血汤，攻坚破积，清热润燥。方中大黄清热破结以逐瘀血；桃仁破血除瘀，润燥解凝；虻虫性寒，破瘀通络。炼蜜为丸，是缓下之法。用酒煎药，引药入血，而使瘀血排出体外。便色如猪肝，则为药已中病。

【选注】

《医宗金鉴》：“产妇腹痛，属于气结血凝者，枳实芍药散以调之；假令服后不愈，此为热灼血干，着于脐下而痛，非枳实、芍药之所能治也。宜下瘀血，主之下瘀血汤，攻热下瘀血也。并主经水不通，亦因热灼血干故也。”

【病案举例】

杨姓，女，32岁。产后4日，恶露行而不畅，有时夹有血块，少腹胀满，拒按，脘闷恶心，自觉有气上冲。舌质红，右边缘有紫斑，苔灰白。病乃恶露瘀阻难行，有瘀血上冲之势。治当急下其瘀血。方拟加味下瘀血汤：

大黄6克（后下），桃仁10克，虻虫6克，当归10克，川芎6克，赤芍10克，牛膝10克，甘草5克。

连服两剂，恶露渐多，挟有紫血块，腹痛减轻。原方既效，将原方桃仁改为6克，大黄改为4克，加艾叶3克，再服两剂，腹痛解除，胀满消散，病即痊愈。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,8:13）

7.产后七八日，无太阳证，少腹坚痛，此恶露不尽，不大便，烦躁发热，切脉微实再倍，发热，日晡时烦躁者，不食，食则谵语，至夜即愈，宜大承气汤主之。热在里，结在膀胱也。见瘕病中。

【诠解】

本条是论述产后瘀血内阻，又兼阳明里实的辨证论治。产后七八天，无太阳表证。由于产后阴血虚少，里热炽盛，热结在下焦，热灼瘀血，干血凝着脐下，故少腹坚痛。热灼胃肠，更耗津液，肠胃实热结滞，故大便干燥不通而烦躁、发热。切脉微沉而实，证明胃肠实热已有积滞，到日晡阳明气旺时，病人则更加发热。食入于胃，长气于阳，若

不食则已，而食入则助胃热。实热过盛，扰乱神明，故生谵语。至夜晚则阳明之气转衰，其病即稍愈，故热轻而谵语暂停。

治以大承气汤，荡胃肠实热积滞，泻血分之热结。方用大黄泻胃肠积滞，泻血分热结；枳实治痞破结，既能除胃肠胀满，又能通利血气；厚朴理气，消腹中胀满；芒硝咸寒，清热软坚。本证用大承气汤，则胃肠实热去，下焦瘀血行，可收一举两得的效果。

【选注】

《医宗金鉴》：“李彰曰：此一节具两证在内，一是太阳蓄血证，一是阳明里实证。因古人文法错综，故难辨也。无太阳证，谓无表证也。少腹坚痛者，以肝藏血，少腹为肝经部分，故血必结于此，则坚痛亦在此。此恶露不尽，是为热在里，结在膀胱，此太阳蓄血证也，宜下去瘀血。若不大便，烦躁，脉实谵语者，阳明里实也，再倍发热者，热在里，蒸蒸发于外也。阳明旺于申酉戌。日晡是阳明向旺时，故烦躁不能食。病在阳而不在阴，故至夜则愈。此阳明腑病也，宜大承气汤以下胃实。”

8. 产后风，续之数十日不解，头微痛恶寒，时时有热，心下闷，干呕汗出，虽久，阳旦证续在耳，可与阳旦汤。即桂枝汤，方见下利中。

【论解】

本条是论述产后中风的辨证施治。产后血虚，荣卫失调，腠理不固，风寒外袭，表证持续数十日不解。卫在外与邪相争，阳气浮动，故时时发热，荣被扰而不守，故汗出、恶寒。风寒阻于太阳之经，故头微痛，而时时有热。表邪将入里，故心下闷而干呕。

产后中风时间虽久，若阳旦汤证仍在，可与阳旦汤，解散风寒，调和营卫。方中桂枝温散风寒，解肌祛风；芍药和营，敛阴止汗；桂枝配芍药，于发汗中而有敛汗之功，桂枝散、芍药收，一散一收，则营卫可调，表邪可解；生姜配桂枝发汗解肌；大枣配芍药滋阴敛荣；甘草性平调和阴阳，调和荣卫。

【选注】

《金匮要略论注》：“中风之轻者，数十日不解，似乎不可责表；然头疼恶寒汗出，时有热，皆表证也。心下闷、干呕，太阳之邪欲内入而内不受。考《伤寒论》有阳旦汤，乃桂枝汤加黄芩，以治太阳中风而挟热者，今久风而热不已，则阳旦证仍在，阳旦汤何不可与，而因循以致误也。”

【病案举例】

王某，女，22岁，干部。1975年3月就诊。患者从产前十来天直至产后第七天，一直呕吐，进食甚少，本地中西医多方治疗无效。细问病人，知有汗出，微恶风等证，视其苔薄白，脉略浮。遂用桂枝汤原方加法夏10克。因呕吐，嘱其少量多次服用。二剂药后，进食已不呕吐，恶风等证亦除。

（摘自《湖北中医杂志》1981,5:26）

9.产后中风，发热，面正赤，喘而头痛，竹叶汤主之。

竹叶汤方

竹叶一把 葛根三两 防风一两 桔梗 桂枝 人参 甘草各一两 附子一枚，炮 大枣十五枚 生姜五两

上十味，以水一斗，煮取二升半，分温三服，温复使汗出。颈项强，用大附子一枚，破之如豆大，煎药扬去沫，呕者，加半夏半升洗。

【诠解】

本条是论述产后中风的辨证论治。产后阴血大虚，虚阳上越，故面色正赤，气喘。正气大虚，复感风邪，故头痛，发热。治疗时，若因其外感风邪，单纯用发汗解表，则浮阳易脱；若因其虚阳上越，单纯用滋阴之药，则使表邪不解。

治以竹叶汤，扶正祛邪，表里兼顾。方中竹叶清热降火，折其阳浮之势；葛根生津，滋润筋脉之急；桔梗上浮清肃肺气；防风散风而不燥血；人参、甘草补中益气；生姜、大枣调和营卫；附子、桂枝扶阳驱邪。此为产后中风，正虚邪盛者，而立补正散邪之方。

【选注】

《金匱要略论注》：“中风发热头痛，表邪也。然面正赤，此非小可淡红，所谓面若妆朱，乃真阳上浮也；加之以喘，气高不下也。明是产后大虚，无阳不能自固，而又杂以表邪，自宜攻补兼施，故以桂、甘、防、葛、桔梗、枣、姜清其在上之邪，竹叶清其胆腑之热，而以参、附培元气，返其欲脱之阳。然以竹叶名汤，要知本寒标热，胆居中道，清其交接之缘，则标本俱安，竹叶实为功之首耳。”

10.妇人乳中虚，烦乱，呕逆，安中益气，竹皮大丸主之。

竹皮大丸方

生竹茹二分 石膏二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分

上五味，末之，枣肉和丸弹子大，以饮服一丸，日三、夜二服。有热者，倍白薇；烦喘者，加柏实一分。

【诠解】

本条是论述哺乳期虚热呕逆的证治。妇人在哺乳期中，乳汁去多，中气虚弱，阴血不足，心肝火旺。心虚火动，则烦乱；中气虚热，胃气上逆，则呕逆。

治以竹皮大丸，安中益气，清降缓中。方中竹茹、石膏清热除烦，降逆止呕；白薇凉血，清热除烦；桂枝、甘草辛甘化气，建中补虚；枣肉滋补阴血。若虚火犯肺而烦喘，则加柏实养血润肺。方中甘草用量独多，取其建中补虚，益阴泻火，而桂枝用量很少，取其温中化气，通脉舒肝之功，二药之剂量安排确有耐人寻味之处。

【选注】

《金匱要略心典》：“妇人乳中虚，烦乱呕逆者，乳子之时，气虚火胜，内乱而上逆也。竹茹、石膏甘寒清胃；桂枝、甘草辛甘化气；白薇性寒入阳明，治狂惑邪气，故曰安中益气。”

11. 产后下利虚极，白头翁加甘草阿胶汤主之。

白头翁加甘草阿胶汤方

白头翁 甘草 阿胶各二两 秦皮 黄连 蘘皮各三两

上六味，以水七升，煮取二升半，内胶令消尽，分温三服。

【诠解】

本条是论述产后下利的证治。产后气血两虚，常有面黄乏力，心烦不眠等证；又有湿热积滞胃肠，传导失职，郁遏不解，损伤肠道脉络，常见发热，腹痛，里急后重，下利脓血等证。

治以白头翁加甘草阿胶汤，清热燥湿，缓中养血。方中白头翁、黄柏、黄连、秦皮清热燥湿，凉血解毒，除胃肠湿热而治下利；阿胶滋阴，养血止血；甘草补气建中，缓解黄连、黄柏之苦。为产后下利常用

之方。

【选注】

《金匱要略心典》：“伤寒热利下重者，白头翁汤主之；寒以胜热，苦以燥湿也。此亦热利下重，而当产后虚极，则加阿胶救阴，甘草补中生阳，且以缓连、柏之苦也。”

【病案举例】

患者女，60余岁。1965年7月，痢下赤白，日数十遍，里急后重。曾服“呋喃西林”二日，效果不显。发热不高，口干，尚不作渴，舌质淡红，舌边呈细小赤点，干而无津，脉象细数。认为老年津血不足，又患热痢，津血更易耗损。拟白头翁加甘草阿胶汤：

白头翁12克，黄连6克，川黄柏6克，秦皮9克，阿胶9克（烔），甘草6克。煎至200毫升，分2次服。上午服第一剂，至晚大便已变粪，续进一剂病愈。

“白头翁加甘草阿胶汤”原出《金匱·妇人产后病脉证治第二十一》，主治“产后下利，虚极”（按“极”字应训弱）。本例虽非产后，但因系老年，津血不足证据显然，有是证则用是药，不必受“产后”字样约束，所以径予本方治愈。

（摘自《中医杂志》1980,2:59）

附方

《千金》三物黄芩汤

治妇人在草蓐自发露得风。四肢苦烦热，头痛者，与小柴胡汤；头不痛但烦者，此汤主之。

黄芩一两 苦参二两 干地黄四两

上三味，以水六升，煮取二升，温服一升，多吐下虫。

【词解】

草蓐：指草席。即临产之时。

【论解】

本方是论述产后发热的证治。产后发热，以感受风寒，邪在少阳，

又有湿热病毒，结于下焦，两者临床为最多。

小柴胡汤方证分析：产后阴血两虚，阳气独盛，在未离产所之时，稍有不慎而感受风寒，致邪客少阳在于胁下，正邪分争，往来寒热，而发热尤甚，手足烦热；邪热上行而头痛。治宜小柴胡汤和解少阳之邪。方中柴胡疏散少阳经之邪；黄芩能清肝胆蕴热；生姜、半夏调胃止呕；人参、甘草、大枣益气和缓，扶正祛邪。本方攻补兼施，补正退邪，一举两得。

三物黄芩汤方证分析：产后阴血两虚，阳气独盛，在未离产所时，下焦感受湿热病毒，湿热蒸熏，发热尤甚，手足烦热。湿热蕴结于下焦，故无头痛等证。治宜三物黄芩汤清热燥湿。方中黄芩清热燥湿，降火解毒，除烦热；苦参清热燥湿，利尿杀虫；干地黄补血养阴。本方既能清热燥湿，除湿热熏蒸之热，又能补血养阴，退血虚之热。

【选注】

《金匱要略论注》：“此言产妇有暂感微风，或在半表里，或在下焦，风湿合或生虫，皆能见四肢烦热证，但以头之痛不痛为别耳。故谓在草蓐，是未离产所也。自发露得风，是揭盖衣被，稍有不慎而暂感也。产后阴虚，四肢在亡血之后，阳气独盛，又得微风，则苦烦热；然表多则上入而头痛，当以上焦为重，故主小柴和解；若从下受之而湿热结于下，则必生虫，而头不痛，故以黄芩清热为君，苦参去风杀虫为臣，而以地黄补其元阴为佐。曰多吐下虫，谓虫得苦参必不安，其上出下出，正未可知也。”

【病案举例】

患者傅某，女，26岁，已婚，社员。

因两下肢阵发性灼热疼痛一个多月，于1971年12月20日来我院就诊。

病史：患者于一个多月前，发现两下肢灼热疼痛，有时阵发性剧痛，每当发作时两小腿中段以下和两脚部均呈深红色，皮肤温度增高，脚掌面出冷汗。遇热容易引起发作，患者常喜欢将两足露于被外，寒凉时症状减轻。

检查：发育营养中等。两小腿中段以下和两足部均呈深红色，皮肤灼热，两下肢动脉搏动正常。两上肢无异常发现。舌苔白腻微黄，舌质淡红。脉象濡弱。

印象：红斑性肢痛症。

治疗经过：此例红斑性肢痛症主要为阴虚内热表现，以养阴、清热、凉血立法，给予三物黄芩汤：生地60克，黄芩、苦参各30克，水煎服。患者当夜服药三剂，两下肢灼热疼痛明显减轻。第二天起每日两剂，连服三天后，两下肢症状完全消失而痊愈。1977年4月随访，经治愈后未复发。

（摘自《山东中医学院学报》1979,3:45）

《千金》内补当归建中汤

治妇人产后虚羸不足，腹中刺痛不止，吸吸少气，或苦少腹中急，摩痛引腰背，不能食饮。产后一月，日得服四五剂为善，令人强壮宜。

当归四两 桂枝三两 芍药六两 生姜三两 甘草二两 大枣十二枚

上六味，以水一斗，煮取三升，分温三服，一日令尽。若大虚，加饴糖六两，汤成内之，于火上暖令饴消，若去血过多，崩伤内衄不止，加地黄六两，阿胶二两，合八味，汤成内阿胶，若无当归，以芎^劳代之，若无生姜，以干姜代之。

【词解】

羸：瘦弱之意。

吸吸：形容呼吸时气少之貌。

【论解】

本方是论述产后腹痛的证治。妇人产后，气血虚少，又有脾胃虚弱，不能生血，血海空虚，则见虚羸不足。脾胃虚弱，则见不能饮食，吸吸少气。气血虚少而不利，不能温润下焦，则见少腹中急，摩痛引腰背。气血不利，进而发展为气滞血瘀，则见腹中刺痛不止。

治以内补当归建中汤。方中当归、芍药补血益阴，以行营气；桂枝温中，通行血气；甘草、饴糖补中扶虚；生姜、大枣以调营卫。此证产后虚羸不足，如单纯滋补阴血则寒凝，单纯温阳则恐劫阴，故用建中补血以和营卫之法。有气血兼顾之能，而无偏颇之弊。本方加减法，若产后失血过多，或崩伤内衄，阴血大亏，可在方中加地黄、阿胶补血敛阴。

【选注】

《金匱要略编注》：“产后体虽无病，血海必虚。若中气充实，气虽虚易能恢复。或后天不能生血充于血海，则见虚羸不足。但血海虚

而经络之虚，是不待言。因气血不利而瘀，则腹中刺痛不止。冲、任、督、带内虚，则少腹中急摩痛引腰背。脾胃气虚，则吸吸少气，不能饮食。故用桂枝汤调和营卫。加当归欲补血之功居多；若大虚加胶饴，峻补脾胃而生气血；若去血过多，崩伤内衄乃血海真阴大亏，故加地黄、阿胶以培之。方后云：无生姜以干姜代之。乃温补之中兼引血药，入血分生血，其义更妙。”

结语

本篇论述妇人产后常见疾病的辨证论治。

产后郁冒与大便难兼见，病情较为复杂，内有血虚，外受寒邪，治以小柴胡汤扶正达邪，和利枢机。产后气血虽虚，然有胃家实证，可用大承气汤，荡涤肠胃实热积滞。总之，妇人产后三大证：痉病、郁冒、大便难，在治疗时，既要养血益阴，又要掌握辨证论治，而不拘一格。切勿因虑其虚，墨守成法，而贻误病机，以使病情加剧。

产后腹痛有四种常见病情，一是血虚内寒，治宜当归生姜羊肉汤，补血散寒；二是气血不畅，治宜枳实芍药散，行气和血；三是瘀血内停，治宜下瘀血汤，活血化瘀；四是瘀血内阻兼阳明里实证，治宜大承气汤，攻下肠胃积滞，兼泻血分实热。

产后中风，若因风寒外袭，可用阳旦汤调和营卫。若因虚阳上越，复感风邪，可用竹叶汤，扶正祛邪。

此外，本篇用竹皮大丸，安中益气，清降缓中，治疗哺乳期虚热呕逆。用白头翁加甘草阿胶汤，清热燥湿，补中养血，治疗产后热利。总之，产后的辨证论治，既要照顾到产后的特点，又不可拘泥于产后的禁忌。

妇人杂病脉证并治第二十二

概说

本篇是论述妇人杂病的辨证论治。在内容上，包括了热入血室、梅核气、脏躁、痞证、瘀血、漏下、腹痛、经水不利、转胞和前阴疾患等十余种疾病。

本篇共有条文二十二条，载方十四首，附方一首。篇中第一条至第四条是论热入血室的辨证论治和方药；第五条至第七条是论妇人梅核气、脏躁、痞证的辨证论治和方药；第八条是对妇人杂病的病因、病机、临床上的各种变化和证治方法作了纲领性的论述，可视为本篇的总论；第九条、第十一条至第十二条是论漏下的证治和方药；第十条、第十三条至第十五条是论经水不利的辨证和治法，其中第十三条是论水与血结的证治；第十六条至十九条是论妇人腹痛、转胞的辨证和治法。第二十条至第二十二条是论妇人阴寒、阴中生疮、阴吹等的前阴证治。

本篇论述妇人杂病的病因，主要有正虚、积冷、结气三个方面的病变。在辨证上，当先分上、中、下三焦的病位；继辨阴阳、寒热、虚实的病性。在治疗上，针对病情，或针或药，有的放矢，才能转危为安。

1.妇人中风七八日，续来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室。其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。方见呕吐中。

【诠解】

本条是论述经水适断热入血室的辨证论治。太阳中风，为时已七八日之久，若正气抗邪有力，则寒热之邪当解。如果在妇人行经之际，血弱气尽，风热邪气袭入血室，与血相搏，结而不行，故经水适断。热结血室，聚结不散，则正邪分争，进退于表里之间，故往来寒热，休作有时，而如疟状。热入血室，内系于肝胆，既不可发汗，又不能下夺。故以小柴胡汤，和解内外表里，透达热邪，则血结可散。质之临床，此方可适当加丹皮、生地、红花之品，其疗效更佳。

【选注】

《注解伤寒论》：“七八日，邪气传里之时，本无寒热，而续得寒热，经水适断者，为表邪乘虚入于血室相搏而血结不行，经水所以断也。血气与邪分争，致寒热如疟，而发作有时，与小柴胡汤以解传经之邪。”

【病案举例】

陈某，女，22岁，产后三日，昼则神识清晰，惟头痛、头晕、寒热交作、微汗，心烦欲呕，入夜则渐见神志恍惚，妄言乱语，呼之不能清楚对答，晨旦则谵妄消失，神清又如常人。家人甚为恐慌，曾在某卫生所用西药镇静剂治疗无效，谵妄不能控制。乃来我院妇产科治疗，仍用镇静剂，但至夜又发作如前状。第三日邀我会诊。家人代述：分娩下血过多，且延时过久（初产妇），产后第二日见头痛寒热，第三日晚上出现妄言乱语。症见：面色淡白，精神疲惫，头痛而晕，往来寒热，体温37.8~38.5℃，心烦心慌，厌食呕吐，少腹不觉胀痛，恶露尚有少量自下，二便通调，舌质淡，苔白中心黄微腻，脉轻取微浮，重按弦虚，稍有紧意。综合四诊分析，此为热入血室，治当重在养血安神，收镇浮阳，佐以和解枢机之剂。

方用：党参12克，当归9克，茯神9克，酸枣仁9克，荆芥穗4.5克，北柴胡6克，法半夏6克，黄芩4.5克，焦山楂4.5克，龙齿12克，五味子3克，炙甘草3克，红枣5枚。暂服一剂，昼服头剂，近夜服二煎。复诊时诉说药后当夜安睡无烦，未见妄言惊乱之象。头痛、寒热均减，胃纳稍进，舌苔渐化，脉缓和无力。前方再进二剂，观察二夜，均能安静，诸症亦悉解。嘱其出院，以饮食调养之。

（摘自《新中医》1981,8:17）

2.妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。治之无犯胃气及上二焦，必自愈。

【诠解】

本条是论述经水适来热入血室的辨证。妇人在患伤寒发热时，经水适时而来，致外邪乘虚袭入血室，而病在血分。其证昼日精神明了，而暮则谵语，所说皆非习见之事，故如见鬼状。因于经水适来而患病，故可定其证，曰热入血室。治之无以下药犯其胃气，以及不可吐、不可汗，恐伤其上、中二焦，如是则可望其愈。宋郭白云认为此证仍与小柴胡汤治疗，以供参考。

【选注】

《金匱要略浅注补正》：“旧注解必自愈，以为不须治之，其邪必

将自解。夫谵语重症，岂易自解，况此明有治之二字，何得以为不须治之？夫《伤寒论》原有热入血室，暮则谵语者，与小柴胡汤，此又承上文小柴胡汤而言，则治之二字，即是按法当与小柴胡汤也。下文无犯胃气及上二焦，又因谵语常法，应用承气，攻其胃与上二焦。此谵语病在下焦血室，与寻常谵语不同，恐人误治，故戒之曰：无犯胃气，及上二焦。意谓但治其下焦血室，而谵语必自愈，不可误治其谵语也。玩其文法自见。”

3.妇人中风，发热恶寒，经水适来，得七八日，热除，脉迟，身凉和，胸胁满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而取之。

【诠解】

本条继论肝经瘀热，热入血室的证治。妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，表证已罢，内传入里，故热除身凉，脉不浮而迟。今热邪乘虚袭入血室，则热与血结，导致肝胆气机不利，故见胸胁满痛，状如结胸。邪热上扰于心，心主言，故见谵语。治疗方法当刺期门，用泻法以行瘀热则愈。

【选注】

《金匱要略心典》：“热除、脉迟、身凉和而谵语者，病去表而之里也。血室者，冲任之脉，肝实主之，肝之脉布胁肋，上贯膈，其支者，复从肝别上膈，注于肺；血行室空，热邪独胜，则不特入于其宫，而亦得游其部，是以胸胁满如结胸状。

4.阳明病，下血谵语者，此为热入血室，但头汗出，当刺期门，随其实而泻之。濈然汗出者愈。

【词解】

濈：汗出之貌。

【诠解】

本条是论述阳明病热入血室的证治。妇人得阳明热病，中焦热盛，虽不值经期，热邪亦可陷入血室，邪热迫血妄行，故下血、谵语；热上熏头面而不能外越，故但头汗出，而身处无汗。治疗方法，当刺期门，以泻热邪，则肝胆气机得调，周身濈然汗出而愈。

【选注】

《金匱要略浅注》：“此言阳明病亦有热入血室者，不必拘于经水之来与断也，但其证下血，头汗出之独异也。盖阳明之热，从气而之

血，袭入胞宫，即下血而谵语，不必乘经水之来，而后热邪得以入之。彼为血去，而热乘其虚而后入，此为热入，而血有所迫而自下也。然既入血室，则不以阳明为主，而以冲任厥阴之血室为主，冲任，奇脉也，又以厥阴之气为主，厥阴之气不通，故一身无汗，郁而求通，遂于其少阳之腑而达之，故头上汗出。治法亦当刺期门，以泻其实。刺已，周身濈然汗出，则阴之闭者亦通，故愈。”

5.妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。

半夏厚朴汤方

《千金》作胸满心下坚，咽中帖帖如有炙肉，吐之不出，吞之不下。

半夏一升 厚朴三两 茯苓四两 生姜五两 干苏叶二两

上五味，以水七升，煮取四升，分温四服，日三、夜一服。

【词解】

炙脔：烤灼的肉块。

【诠解】

本条是论述妇人咽中痰凝气滞的证治，本病后人称为“梅核气”。由于情志郁结，气郁化火，炼液成痰，凝于咽喉，自觉咽中如一肉块梗阻其间，吐之不出，咽之不下。兼见精神忧郁，胸闷太息等证。本证不单见于妇人，而男子往往也有。

治用半夏厚朴汤，解郁化痰，理气开结。方中紫苏气味芳香，有散郁理气作用；厚朴降气，开凝散结而通利痰气；茯苓行饮化饮，以澄痰本；半夏降气涤痰；生姜温中化饮，以去痰凝，则咽中炙脔之感可除。

【选注】

《金匱要略心典》：“此凝痰结气，阻塞咽嗑之间，《千金》所谓咽中帖帖，如有炙肉，吞不下，吐不出者是也。半夏、厚朴、生姜辛以散结，苦以降逆；茯苓佐半夏利痰气，紫苏芳香，入肺以宣其气也。”

【病案举例】

石杨氏，女，71岁。于1980年10月28日就诊。

患精神病已四年余，曾用氯丙嗪、安定、泰而登等药治疗，未见明显好转。近一月来，症状加重，精神时而紧张，时而抑郁，多言恐惧，

言语不避亲疏，善悲欲哭，四出奔走，口中常喃喃自语，尤以夜间为甚。清晨及上午多神情呆滞，常蜷缩于阴暗处，口中流涎。伴咳嗽痰多，痰色清稀，饮食欠佳。察其面色萎黄，营养稍差，舌质淡、苔白腻，脉弦缓。脉症互参，显系气机郁结，肺胃宣降失常，痰涎凝聚，加之气滞痰凝，脾虚不能化湿，痰湿交阻，袭扰神明。方用半夏厚朴汤加减：

半夏10克，厚朴10克，茯苓12克，生姜6克，苏叶8克，橘红9克，胆南星12克。水煎服，3剂。

服后精神症状大为减轻，已能正常答话，流涎几无，咳嗽减轻，食欲亦增。唯夜间仍有乱语，少寐。嘱再服原方三剂，神志清楚，已能做轻活，随访半年未复发。

（摘自《陕西中医》1981,5:12）

6.妇人藏躁，喜悲伤，欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之。

甘草小麦大枣汤方

甘草三两 小麦一升 大枣十枚

上三味，以水六升，煮取三升，温分三服，亦补脾气。

【论解】

本条是论述脏躁病的证治。夫六腑为阳，五脏为阴。阳为气，阴为血，若血虚不濡，则生脏躁。其病以心肝为首者，因心生血，而肝藏血。故病则悲伤欲哭，像如神灵所做，此为心病反映。至于数欠喜伸，而是肝肾病象。所以然者，血虚不濡，内必关心，阴脏既伤，而穷必及肾，故治疗用甘药，所以补心肝之血而濡其燥也。

治以甘草小麦大枣汤，滋润五脏之燥。方中甘草、大枣助脾益血，可以滋润五脏，缓和躁急；小麦补养心肝之血，除脏躁之热，敛心气而安神志。

【选注】

《医宗金鉴》：“脏，心脏也。心静则神藏。若为七情所伤，则心不得静，而神躁扰不宁也。故喜悲伤欲哭，是神不能主情也；象如神灵所凭，是心不能神明也，即今之失志癫狂病也。数欠伸，喝欠也，喝欠

顿闷，肝之病也。母能令子实，故证及也。”

【病案举例】

1936年于山东菏泽县医院，诊一男子，年约30余，中等身材，黄白面色，因患精神病，曾两次去济南精神病院治疗无效而来求诊。查其具有典型的悲伤欲哭，喜笑无常，不时欠伸，状似“巫婆拟神灵”的脏躁症。遂投以甘麦大枣汤：甘草9克，整小麦9克，大枣6枚，药尽7剂而愈，追踪3年未发。

1940年于滦县诊治一女性，徐某，19岁，欠伸不安，哭笑无常，得脏躁症，亦投上方，其父曰：“方中之药，系经常之食品。”归后，取仓中之小麦约500克，大枣500克左右，购甘草一大把，用锅煎熬之，令其女恣饱饮之，药后患者感头晕颇重，继之昏睡一昼夜始醒，翌日其父来述服药经过，嘱按原方服之。进数剂，经久未发。

（摘自《岳美中医案集》第96页）

7.妇人吐涎沫，医反下之，心下即痞，当先治其吐涎沫，小青龙汤主之。涎沫止，乃治痞，泻心汤主之。

小青龙汤方见肺痈中

泻心汤方见惊悸中

【诠解】

本条是论述寒饮误下成痞的先后治法。妇人上焦停有寒饮，又感寒邪，内饮外寒，上迫于肺，故咳吐涎沫。治用小青龙汤以温散寒饮。若医误用苦寒之品攻下，损伤胃气，寒饮凝结，心下气阻而作痞。上寒犹在，故吐涎沫不止。此证若先以泻心汤治痞，则寒邪内传，而寒饮更甚；若先以小青龙汤解散外寒，消除内饮，则痞气无外援其证易除。故当先治其吐涎沫，小青龙汤主之。涎沫止，转治其痞，而泻心汤为不易之法。

【选注】

《金匱要略心典》：“吐涎沫，上焦有寒也。不与温散而反下之，则寒内入而成痞，如伤寒下早例也。然虽痞而犹吐涎沫，则上寒未已，不可治痞，当先治其上寒，而后治其中痞，亦如伤寒例，表解乃可攻痞

也。”

8. 妇人之病，因虚积冷结气，为诸经水断绝，至有历年，血寒积结胞门。

寒伤经络，凝坚在上，呕吐涎唾，久成肺癰，形体损分；在中盘结，绕脐寒疝，或两胁疼痛，与藏相连，或结热中，痛在关元，脉数无疮，肌若鱼鳞，时著男子，非止女身；在下未多，经候不匀，令阴掣痛，少腹恶寒；或引腰脊，下根气街，气冲急痛，膝胫疼烦。

奄忽眩冒，状如厥癫，或有忧惨，悲伤多嗔，此皆带下，非有鬼神。久则羸瘦，脉虚多寒。

三十六病，千变万端，审脉阴阳，虚实紧弦，行其针药，治危得安，其虽同病，脉各异源，子当辩记，勿谓不然。

【词解】

胞门：即子宫。

形体损分：损伤阴分而形体消瘦。

关元：穴名。脐下三寸，为任脉所属，此处泛指下焦。

在下未多，经候不匀：指月经量少，经期不准。

气街：鼠蹊上一寸，又名气冲。

奄忽眩冒：忽然发生头目眩晕。

厥癫：指昏厥癫狂一类疾病。

多嗔：时常发怒。

带下：泛指妇女经带之病。

【诠解】

本条是论述妇人杂病的病因、病机和辨证论治原则。第一段说明妇人杂病的病因，主要有虚、积冷、结气三个证候。“虚”，为体质虚弱，气虚血少，或阴阳不足，抗病能力薄弱，易感邪气。“积冷”，为感受寒邪，凝结不散，积久则坚。“结气”，为肝郁气郁，气机不畅，久而气结不通。如果联系起来讲，就是气虚血少，风冷凝聚，气结不通，而引起月经不调，甚至月经断绝，经过几年，血寒积结在子宫，形成难愈的病根。

第二段说明虚冷结气在上、中、下三焦的病变情况。虚冷结气伤于经络，经络凝滞，结而不通，若结在上焦，使肺不能敷布津液，所以咳

吐涎沫，常咳不止，就会形成肺痿证；寒郁日久，则可化热，热毒腐肉化脓，则成为肺痈。肺痿、肺痈，皆能损伤阴分，阴有形，阴伤则形体消瘦。

虚冷结气盘结在中焦，也有寒凝和化热两种可能。寒冷凝聚，气结不通，伤于肝脾经络，盘结肝脾，则绕脐寒疝疼痛；结于肝经，则两胁疼痛，痛连内脏。寒冷结气郁于内，正邪相争，化热于中，热灼血干，形成瘀血，停在少腹，则痛在关元。郁热耗损营血，血枯不荣于外，故脉数发热，尚无疮疡，而见皮肤枯燥，状如鳞甲。这种病变，男子与妇人均可发生。疮疡为湿热火毒聚于一处，腐肉化脓而成；本证为热灼血干，血枯不荣，故尚无疮疡可言。

虚冷结气若在下焦的冲任，由于气虚血少而正气不足，寒冷凝聚，气结不通而邪伤经脉，故症见月经量少，不能畅行，经期不调，前阴掣痛，少腹恶寒等候。寒冷凝聚，牵引腰脊；或下连气街，则可发生冲气急痛，或牵引两腿膝胫疼痛烦闷的现象。

第三段说明“虚冷结气”，引起情志方面的各种疾患。虚冷结气，伤于带脉以下的“胞门”，则有在上血虚不养和血热上亢的两种不同：血虚不养，阴血不能上濡于头目，故可忽然发生眩冒；血热上亢，是气血郁阻化热，而血热上亢，状如昏厥癫狂等一类疾病；血虚生热进而化燥，则不能润于内脏，故使人烦躁发怒。此皆妇人带下疾患而虚寒积结胞门之所致，故其精神有上述之改变，如有鬼神所附。本证经久不愈，则气血不生，故形体消瘦，脉来虚弱。

第四段说明妇人杂病的辨证论治原则。妇人杂病有三十六种，变化多端，极为复杂。在辨证时，要应用切脉等诊断方法，辨别证候的阴阳寒热虚实。在施治时，要根据辨证结果，给予针灸、药物等恰当的治疗，使病人转危为安。“其虽同病”，是说明很多疾病病形相近似。由于脉和脉象出现的部位不同，因而疾病的性质和部位也就不同，当医生的应当认真详加审辨。要掌握这些辨证论治的原则，不要产生无所谓的思想而认为不然。

【选注】

《金匱要略心典》：“此言妇人之病，其因约有三端：曰虚、曰冷、曰结气。盖血脉贵充悦，而地道喜温和，生气欲条达也。否则，血寒经绝，胞门闭而经络阻矣；而其变证，则有在上、在中、在下之异。在上者，肺胃受之，为呕吐涎唾，为肺痈，为形体消瘦，病自下而至上，从炎上之化也。在中者，肝脾受之，或寒疝绕脐，或胁痛连脏，此病为阴。或结热中，痛在关元，或脉数肌干，甚则并着男子，此病为热

中，为阴阳之交，故或从寒化，或从热化也。在下者，肾脏受之，为经候不匀，为阴中掣痛，少腹恶寒；或上引腰脊，下根气街，及膝胫疼痛。肾脏为阴之部，而冲脉与少阴之大络，并起于肾故也，甚则奄忽眩冒，状如厥癫；所谓阴病者，下行极而上也。或有忧惨悲嗔，状如鬼神者，病在阴则多怒及悲愁而不乐也。而总之曰：此皆带下；带下者，带脉之下，古人列经脉为病；凡三十六种，皆谓之带下病，非今人所谓赤白带下也。至其阴阳虚实之机，针药安危之故，苟非医者辨之有素，乌能施之而无误耶？三十六病者，十二癥、九痛、七害、五伤、三瘕结也。”

9.问曰：妇人年五十所，病下利数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下。何以故？曾经半产，瘀血在少腹不去。何以知之？其证唇口干燥，故知之。当以温经汤主之。

温经汤方

吴茱萸三两 当归 芍药^芤各二两 人参 桂枝 阿胶 牡丹皮
去心 生姜 甘草各二两 半夏半升 麦门冬一升，去心

上十二味，以水一斗，煮取三升，分温三服。亦主妇人少腹寒，久不受胎，兼取崩中去血，或月水来过多，及至期不来。

【词解】

下利：指前阴下血。

【诠解】

本条是论述瘀血引起崩漏的辨证论治。妇人年已五十岁左右，此时冲任皆虚，既往又曾经半产，则正气虽虚而少腹瘀血未尽。血寒积结胞门，寒伤经络，血不归经，则腹满里急，崩漏下血数十日不止。夫崩漏则伤血耗阴，阴虚则生内热，故暮即发热，手掌发热而心烦；阴津不能上润，则唇口干燥。

本病为冲任虚寒，少腹瘀血，引起崩漏不止等证。治以温经汤温气濡血，调和冲任。方中吴茱萸、桂枝、生姜温和肝胃，以暖胞门；当归、川芎、芍药，阿胶补血益阴，以补肝胃；丹皮配芍药则凉血退热；麦冬有润燥续绝，补养心肺之功；人参、甘草则补气扶虚，以开化源；半夏降逆止咳而和胃气。诸药合用，可以暖宫温经，补血去瘀，故亦治

妇人少腹积寒，瘀血内停之崩漏下血，月经过多，至期不来，久不受胎等证。

【选注】

《医宗金鉴》：主妇人年已五十，冲任皆虚，天癸当竭，地道不通矣。今下血数十日不止，宿瘀下也。五心烦热，阴血虚也。唇口干燥，冲任血伤，不上荣也；少腹急满，胞中有寒，瘀不行也。此皆曾经半产崩中，新血难生，瘀血未尽，风寒客于胞中，为带下，为崩中，为经水愆期，为胞寒不孕。均用温经汤主之者，以此方生新去瘀，暖子宫，补冲任也。”

【病案举例】

张姓，女，30岁。患者于21岁时生一女孩，产后因经期发热过饮生冷，导致月经不调。经来少腹剧痛，形寒怕冷，喜热熨，喜按，经期每次过期，有时40多天方行。脉象沉迟，舌淡苔白，边缘有瘀斑。病因寒凝气滞血瘀，故宫寒而不孕，月经不调。治以温经汤化裁，暖宫而调经。

处方：吴茱萸5克，川芎6克，当归、白芍各10克，桂枝8克，丹皮6克，生姜3片，甘草3克，半夏6克。

嘱于每月经行前服5-7剂，经行即停服药。连服半年，月经渐调正常。后怀孕，生一男孩。原方后云：“亦主妇人少腹寒，久不受胎。”用之竟获良效。

（摘自《辽宁中医杂志》1980,8:14）

10.带下经水不利，少腹满痛，经一月再见者，土瓜根散主之。

土瓜根散方

阴癰肿亦主之。

土瓜根 芍药 桂枝 虻虫各三分

上四味，杵为散，酒服方寸匕，日三服。

【诠解】

本条是论述瘀血经水不利的辨证论治。瘀血停滞，阻碍行经，月经似通不通，欲止不止，故月经虽行而不利，不利则少腹满痛，按之有硬块，月经不准，而一月再见。

治以土瓜根散，活血通瘀。方中土瓜根通经消瘀血；虻虫破血开闭；桂枝、芍药温阳益阴，通行营卫而调经。

【选注】

《金匱要略论注》：“带下即前所谓此皆带下，非专指赤白带也。盖古人列妇人因经致病，凡三十六种，皆谓之带下病，故此节冠以带下二字，后不复重出耳。不利者，不能如期也。因寒而瘀，故少腹满痛；然既有瘀而不利，则前经行未畅者，不及待后月正期，乃一月而再见也。药主土瓜根散者，土瓜即草部王瓜也，性苦寒，善驱热行瘀；虻虫兼活血；芍药敛阴中正气；桂枝行经络之滞，而积冷自散。因有瘀滞，故以土瓜为主，必合桂枝，所谓寒因热用也。”

11.寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相搏，此名曰革。妇人则半产漏下，旋覆花汤主之。

旋覆花汤方

旋覆花三两 葱十四茎 新绛少许

上三味，以水三升，煮取一升，顿服之。

【论解】

本条是论半产漏下精血亏损的辨证论治。妇人阴血亏损，引起阳气衰微和虚阳外浮两种病情。阴血亏损，阳气衰微，则阴寒凝固，故脉弦。阴血亏损，虚阳外浮，则阳热外动，故脉芤大。阴寒凝固与虚阳外浮同时存在，脉象弦紧，芤大中空，如按鼓皮，故名曰革。阳气衰微，阳不固阴，阴血不宁，见此脉者，则为妇人半产漏下，崩中伤血。

治以旋覆花汤，助气血之生化，行气血之瘀滞，以待生机自复。方中旋覆花理结气，通血脉，调寒热，疏肝助开发之气；葱白温通阳气，而有阳生阴长之义；新绛理血散寒，乃去瘀而生新之旨。

本证大虚难补，因半产漏下之后，而内多挟瘀，故治从肝经入手，助其生化之气，行其气血之滞，而后则补养阴血，温散阴寒。

【选注】

《金匱要略心典》：“本文已见虚劳篇中，此去男子亡血失精句，而益之曰旋覆花汤主之，盖专为妇人立法也。详《本草》旋覆花治结气，去五脏间寒热，通血脉；葱主寒热，除肝邪；绛帛入肝理血，殊与

虚寒之旨不合。然而肝以阴脏而舍少阳之气，以生化为事，以流行为用，是以虚不可补；解其郁聚，即所以补；寒不可温，行其血气，即所以温；固不可专补其血，以伤其气；亦非必先散结聚，而后温补，如赵氏、魏氏之说也。”

【病案举例】

戴某，女，社员，1975年来我处就诊。自诉于去年小产后，阴道出血至今未净。诊脉细数，舌红润苔白，小腹部时有隐痛，下血量虽不多，但终日淋漓不清。其症显属半产后瘀血结聚，用旋覆花汤治之。

处方：旋覆花10克（布包），新绛（茜草）12克，青葱10根，生地15克，当归10克，白芍6克，川芎6克，三剂。

二诊：服药后下血块数枚，血渐止，腹亦不痛。继以十全大补汤调理而愈。

（摘自《江苏中医杂志》1981,3:19）

12.妇人陷经漏下，黑不解，胶姜汤主之。臣亿等校诸本无胶姜汤方，想是妊娠中胶艾汤。

【词解】

黑不解：指陷下之经色黑而不解除。

【论解】

本条是论述虚寒漏下的证治。冲任虚寒，新血不生，旧血因寒而凝，败血涩滞而下，故漏下不止，血色黑暗。

治宜胶艾汤，温补冲任，养血止血。方中阿胶养血以止血，去瘀生新；川芎、地黄、芍药、当归和血养肝，去瘀生新；生姜散寒达气，郁者散之，陷者举之；艾叶温经暖胞；甘草则补中益气。

【选注】

《医宗金鉴》：“李彣曰：陷经漏下，谓经脉下陷，而血漏下不止，乃气不摄血也。黑不解者，瘀血不去，则新血不生，荣气腐败也。然气血喜温恶寒，用胶姜汤温养气血，则气盛血充，推陈致新，而经自调矣。”

13.妇人少腹满，如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血，俱结在血室也，大黄甘遂汤主之。

大黄甘遂汤方

大黄四两 甘遂二两 阿胶二两

上三味，以水三升，煮取一升，顿服之，其血当下。

【词解】

敦：音对。古代盛粮食的器具，口底皆锐，腰部硕大突出。

【诠解】

本条是论述产后水血俱结于血室的辨证论治。产后血室恶露未尽，气血不畅，津液不能入经化血流转上下，而反渗入血室，水与血俱结在血室，故少腹满，形如敦状。血室气血不畅，若影响膀胱气化不利，故小便微难。上焦气化如常，故口中不渴。

治用大黄甘遂汤，破血逐水。方中大黄攻瘀血；甘遂逐积水；阿胶补血。瘀浊去后，阴血亦复，正所谓且攻且守之法。

膀胱蓄水，为膀胱气化不行，津液不能上承，亦不能下达，故口渴，小便不利。血室内瘀血停留，气化如常，故小便自利。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“妇人少腹满如敦状者，腹皮加厚也；小便微难者，有形之邪格阻于下也。如此宜为水气之病，格阻正津上冲胸喉作渴，如水气病所云矣。乃不渴，知非但水邪，且合瘀血也。惟水邪与瘀血俱结在血室，同为有形之物，斯可为实邪而驱逐攻下也。主以大黄甘遂汤，大黄下血，甘遂逐水，二邪同治矣。入阿胶者，就阴分下水血二邪，而不至于伤阴也。顿服之，血当下，血下而水自必随下矣。此瘀血积于产后，虽在血室，又不同于抵挡汤丸下之，下之于大便，此即《产后篇》中所言热在里，结在膀胱者也。彼单为血，故用大承气汤，此兼水邪，故用大黄甘遂汤。邪有专兼，治亦分专兼矣。”

14. 妇人经水不利下，抵挡汤主之。亦治男子膀胱满急有瘀血者。

抵挡汤方

水蛭三十个，熬 虻虫三十枚，熬，去翅足 桃仁二十个，去皮尖 大黄三两，酒浸

上四味，为末，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升。

【诠解】

本条是论述经水不利属于瘀血结实的证治。经水不利下，即经闭不行之意。由于瘀血内结，日益增大，阻碍经血，所以经闭不行。瘀血经闭不行，常见少腹硬满，结痛拒按，小便自利，脉沉涩迟等脉证。

治以抵当汤，破血逐瘀。方中水蛭、虻虫攻其瘀，大黄、桃仁下其血。

【选注】

《金匱要略论注》：“不利下者，明知有血欲行，而不肯利下，既非若久闭不止，亦非若行而不畅。如一月再见者，是有形之物碍之，故以大黄、桃仁、水蛭、虻虫峻逐之。”

【病案举例】

宋某，女，18岁。于1970年8月患癫狂。目光异常，时而若有所思，时而若有所见，时而模仿戏剧人物，独自动作吟唱。入夜尤剧，妄言躁狂欲走。中西医多方治疗未效。病至半月，势渐重笃，卧床不起，饮食不进有数日，衣老诊视，脉之，六部数疾，尺滑有力；按之，少腹上及脐旁坚硬急结。询其经事，家人回答初得病时正值经期。大便周余未解，小溲尚通。舌黯红干燥。乃曰：王氏《脉经》说“尺脉滑，血气实，妇人经水不利”……脉证合参，属瘀热发狂，急宜泄热破瘀。疏抵当汤：桃仁25克，大黄10克，水蛭10克，虻虫10克。适缺虻虫，嘱先服下看。翌日诊视，药后大便得通，证无进退。曰：证属瘀热发狂无疑，抵当何以不效？殆缺虻虫之故，仍用前方，亟令觅得虻虫。时值夏月，家人乃自捕虻虫三十余枚合药。服后三时许，果从前阴下瘀血紫黑，夹有血丝血块，大便亦下胶黑之屎。令以冰糖水饮之，沉沉睡去；嘱勿扰唤。翌晨，神清索食，惟觉困乏，疏方生地、白薇、丹参、莲心、荷叶、琥珀调之，竟愈。愈后询之，自言先因郁怒，经期复受惊恐，遂血阻不行，继乃发病。现已婚生子，未再复发。

（摘自《上海中医药杂志》1980,3:18）

15. 妇人经水闭不利，藏坚癖不止，中有干血，下白物，矾石丸主之。

矾石丸方

矾石三分，烧 杏仁一分

上二味，末之，炼蜜和丸枣核大，内藏中，剧者再内之。

【词解】

藏坚癖不止：是指子宫内干血坚结不散。

白物：即白带。

内藏中：内，读纳，即以坐药纳入阴道中。

【诠解】

本条是论述湿热白带的证治。由于胞宫内有干血不去，经行不畅，甚至经水闭塞，瘀血内阻，积湿化热，腐败而下，所以淋下白物。

治以矾石丸清热燥湿，而止白带。方中矾石清热燥湿，解毒杀虫，化腐收敛，可止白带；杏仁通利肺气，化湿利水，润燥行血。矾石丸为坐药，纳入阴中，既能清热燥湿而止白带，又能内润干血去坚癖。用此方，白带止，瘀血下，一举两得。如瘀血不下，干血不润，再用活血通经之品，亦易于收效。

【选注】

《医宗金鉴》：“藏，阴内也。不止，不去也，经水闭而不通。瘀，宿血也。阴中坚块不去，血干凝也。下白物，化血成带也。用矾石丸坐药治之。此方治下白物，若从湿化者可也，恐未能攻坚癖干血也。”

16.妇人六十二种风，及腹中血气刺痛，红蓝花酒主之。

红蓝花酒方疑非仲景方

红蓝花一两

上一味，以酒一大升，煎减半，顿服一半，未止再服。

【诠解】

本条是论述风寒气滞血瘀腹痛的辨证论治。多种风寒邪气，袭入腹中，风邪与血气凝搏，气血不得流转，脏腑失和，月事闭塞，故腹中血气刺痛。

治宜红蓝花酒，温通气血，气行血开，则风自散，而刺痛自止。

【选注】

《金匱要略方论本义》：“风邪入腹，扰乱气血，腹中必刺痛，主之以红蓝花酒。酒以温和气血，红蓝花以行散其瘀，而痛可止。此六十二种之风名，不过言风之致证多端，为百病之长耳，不必拘其文而凿求之。”

17.妇人腹中诸疾痛，当归芍药散主之。

当归芍药散方见前妊娠中

【诠解】

本条是论述肝脾不调腹痛的证治。妇人腹中疼痛，多因肝脾不和之所致。如脾虚不化而生湿，湿盛则气阻，肝血不濡，故可引发腹中疼痛。

治宜当归芍药散，补脾渗湿，养血平肝。方中当归养血柔肝；川芎调血疏肝；芍药养血平肝，使肝和而血脉不急，血脉不急则疼止；茯苓、白术健脾化湿；泽泻则利水滋阴，以使脾气健运，湿邪自去，气血畅达，则腹痛等证自愈。

【选注】

《金匱要略阐义》：“妇人之病，由肝郁者居多。郁则气凝血滞，或痛或胀，或呕或利。云腹中诸疾痛，诸者，盖一切之辞。当归芍药散，舒郁利湿，和血平肝，即有兼证，不妨加味治之，诚妇人要方也。”

18.妇人腹中痛，小建中汤主之。

小建中汤方见前虚劳中

【诠解】

本条是论述虚寒腹痛的证治。由于脾胃虚寒，气血来源不足，不能煦濡筋脉，所以腹中绵绵作痛，喜温喜按。临床常见虚烦心悸，面色无华，舌质淡嫩，脉弦而涩。用小建中汤调和脾胃，建中阳生化气血，气血流畅，温养筋脉，则腹痛等证自止。

【选注】

《金匱要略心典》：“营不足则脉急，卫不足则里寒；虚寒里急，腹中则痛；是必以甘药补中缓急为主，而合辛以生阳，合酸以生阴，阴阳和而营卫行，何腹痛之有哉。”

19.问曰：妇人病，饮食如故，烦热不得卧，而反倚息者，何也？师曰：此名转胞，不得溺也。以胞系了戾，故致此病，但利小便则愈，宜肾气丸主之。

肾气丸方

干地黄八两 薯蓣四两 山茱萸四两 泽泻三两 茯苓三两 牡丹皮三
两 桂枝 附子炮，各一两

上八味，末之，炼蜜和丸梧子大，酒下十五丸，加至二十五丸，日再服。

【词解】

转胞：胞是指膀胱；转是转动，指功能异常。

了戾：扭转乖戾不和。

倚息：以背依物而呼吸，叫“倚息”。

【诠解】

本条是论述妇人转胞的辨证论治。因为病不在脾胃，所以饮食如常。由于肾气虚弱，不能温暖膀胱，膀胱虚寒，气化不行，所以不得溺。尿液聚在膀胱不出，常见脐下急痛等证。水气为病而使肾阳不得下潜，所以烦热；肾不纳气，而反倚息不得卧。

【选注】

《金匱要略心典》：“饮食如故，病不由中焦也。了戾与繇戾同，胞系繇戾而不顺，则胞为之转，胞转则不得溺也。由是下气上逆而倚息，上气不能下通而烦热不得卧。治以肾气者，下焦之气，肾主之；肾

气得理，庶繚者顺，戾者平，而闭乃通耳。”

20.蛇床子散方 温阴中坐药。

蛇床子仁

上一味，末之，以白粉少许，和合相得，如枣大，绵裹内之，自然温。

【诠解】

本条是论述寒湿带下的辨证论治。由于胞门受寒，阴冷寒湿内停，所以少腹恶寒，阴中作冷，或阴内瘙痒，白带淋漓，阴内疮肿等证。

治宜蛇床子散，温散阴中寒湿。蛇床子仁为细末，以铅粉少许，和合相得，如枣大，绵裹内入阴中。方中蛇床子苦温，暖宫除湿，杀虫止痒；白粉，即铅粉，有燥湿杀虫之功。

【选注】

《金匱要略心典》：“阴寒，阴中寒也。寒则生湿，蛇床子温以去寒，合白粉燥以除湿也。此病在阴中而不关脏腑，故但纳药阴中自愈。”

21.少阴脉滑而数者，阴中即生疮，阴中蚀疮烂者，狼牙汤洗之。

狼牙汤方

狼牙三两

上一味，以水四升，煮取半升，以绵缠筋如茧，浸汤沥阴中，日四遍。

【诠解】

本条是论述湿热阴中生疮的证治。湿热蕴于下焦，故少阴脉滑而数，主阴中有伏热。湿热下注，腐蚀糜烂，故阴中生疮而痛痒不止。

治宜狼牙汤洗涤阴中。狼牙草味苦性寒，清热燥湿杀虫。

【选注】

《金匱要略心典》：“脉滑者，湿也；脉数者，热也；湿热相合，而系在少阴，故阴中即生疮，甚则蚀烂不已。狼牙味酸苦，除邪热气，疥瘙恶疮，去白虫，故取治是病。”

22.胃气下泄，阴吹而正喧，此谷气之实也，膏发煎导之。

膏发煎方见黄疸中

【诠解】

本条是论述阴吹的证治。热滞于肠，腹胀而大便干燥，大便不下，压迫阴道变窄，浊气奔泄于下，发出声音，故叫“阴吹而正喧”。

治以膏发煎，润肠通便，补血和阴。方中猪膏补阴滋燥而滑润大肠；乱发通利关格以行阴气，升降得宜，则阴吹可止。

【选注】

《金匱要略心典》：“阴吹，阴中出声，如大便矢气之状。连续不绝，故曰正喧。谷气实者，大便结而不通，是以阳明下行之气，不得从其故道，而乃别走旁窍也，猪膏发煎润导大便，便通，气自归矣。”

【病案举例】

林某，女，40岁，营业员。自述有结核病史。近一年来，经常喘咳，大便秘结及阴道排气，每因感冒诸证加剧。服中药一年，喘咳鲜有发作，但阴吹不减，反有加重，多随大便秘结程度而起伏，甚则频发不已，傍人亦可闻及。自认为“怪病”，不愿就医，常服大黄一类泻下药物，偶尔大便得通，“阴吹”缓解，一旦停药，证复如故，以致行走坐卧，阴吹不已，方来就诊。所述除便秘及阴吹之外，余无所苦。察其舌质，舌苔均属正常，脉细而数。宗仲景阴吹论治，予以膏发煎；生猪板油250克，净人发15克。

制法：将人发用肥皂水洗去油污，再以清水漂洗待净，干后备用。生猪板油切碎，如日常炼油之法，待出油后捞去油渣，将人发，浸没油中，微火慢炼，至发溶解为度。若火候掌握不恰当，或发未完全浸没油中，不能尽溶而油已见黄时，即终止再炼。将残发捞出，冷后杵细，再拌入油中，即可服用。

服法：1日3次，每次约20毫升，服后可用开水净口。

患者如法服3日，便秘缓解，阴吹次数减少。服至一周，大便畅

快，阴吹停止，随访3年，病未复发。

（摘自《成都中医学院学报》1980,1:26）

23.小儿疳虫蚀齿方疑非仲景方

雄黄 葶苈

上二味，末之，取腊日猪脂，熔，以槐枝绵裹头四五枚，点药烙之。

【诠解】

本方说明小儿疳虫蚀齿的治法。小儿胃肠湿热停留，疳热生虫，虫蚀于齿，名牙疳。虫寄生肠内，耗伤气血，则腹胀消瘦，烦热多汗，名曰疳积。虫下蚀于前后两阴，名蚀疮。

治以小儿疳积虫蚀齿方，清热利湿，杀虫。方中雄黄苦辛寒有毒，解毒疗疮，杀百虫；葶苈子辛苦寒，通利水湿；猪脂炼净而不腐，为解毒杀虫调炼而成膏。

【选注】

《金匱要略直解》：“小儿胃中有疳热则虫生，而牙齿蚀烂。雄黄味辛，葶苈味苦，辛苦能杀虫故也。”

结语

本篇论述妇人杂病的病因，主要有虚、积冷、结气三个方面。气虚血少，寒冷凝聚，气结不通，引起月经断绝，日久则血寒积结在子宫，形成难愈的病根。而且，由此引起上、中、下三焦的很多疾病。关于妇人杂病的病因、病机、三焦辨证、寒化热化、辨证论治原则等内容，要结合全篇内容去进行研究。

关于热入血室的证治。有经水适断之际，风热与血结于血室，可用小柴胡汤清解邪热，透出阴分之邪。有经水适来热入血室，致血分有热，治用小柴胡汤加生地黄、丹皮等药，清透与凉血兼用，必自愈。也有热入血室，胸胁满如结胸状的，可以针刺期门，以泻肝胆瘀热。有阳明热盛，热入血室，下血谵语，但头汗出，也可用刺期门疏泄肝经之

热。

梅核气，是由于咽中痰凝气结所致，可用半夏厚朴汤解郁化痰。脏躁病，是内脏虚热，燥而不润，精神失养，可用甘草小麦大枣汤，补血以滋脏阴。心下作痞，是由于外寒内饮，误用苦寒攻下，寒饮内结而成。先以小青龙汤散寒消饮，再用甘草泻心汤和中消痞。

若是冲任虚寒，少腹瘀血引起的崩漏，可用温经汤温养血脉，去瘀生新。若瘀血内结而使经水不利，可用土瓜根散活血通瘀。至于半产漏下，精血亏损已极，可用旋覆花汤，助其生化之气，以理未尽之瘀。虚寒漏下不解，可用胶艾汤，温补冲任，以摄经血。若水血同时结于血室，少腹胀满而如敦状者，可用大黄甘遂汤，破血逐水则愈。若瘀血之经闭，可用抵当汤，破血逐瘀通经。

风寒气滞血瘀腹痛，可用红蓝花酒温通气血；肝脾不调之腹痛，可用当归芍药散，调和气血，健脾化湿；虚寒腹痛，可用小建中汤健脾缓急。

湿热白带，可用矾石丸。寒湿白带，可用蛇床子散。妇人转胞，治宜肾气丸。阴中生疮，治宜狼牙汤。阴吹病，可用膏发煎。此篇精神是观其脉证，随证治疗，举一反三，以概其余而已矣。

杂疗方第二十三

概说

本篇主要是论述杂病危急证的辨证论治。其内容较为广泛，涉及的病证达十多种。本篇共有条文十六条，载方二十二首，除第一、二、四条是论五脏虚热的治法、伤寒愈后的调治等病外，其他十三条均论述了各种危急重症、卒死、自缢死、溺死的辨证论治。

本篇中有的条文虽有脱简，其言简难懂，但本篇中有些方剂，至今仍在临床中广泛运用，其疗效颇佳。某些治疗方法，对于指导中医临床急救方面，有很大的实践价值。尤其对卒死、自缢死、溺死等危急证的治疗方法，是祖国医学中治疗急症的宝贵遗产，值得学习和研究。

1.退五藏虚热，四时加减柴胡饮子方

冬三月加：柴胡八分 白术八分 大腹槟榔四枚，并皮子用陈皮五分
生姜五分 桔梗七分

春三月加：枳实 减：白术 共六味

夏三月加：生姜三分 枳实五分 甘草三分 共八味

秋三月加：陈皮三分 共六味

上各**呖**咀，分为三贴，一贴以水三升，煮取二升，分温三服，如人行四五里进一服。如四体壅，添甘草少许，每贴分作三小贴，每小贴以水一升，煮取七合，温服，再合滓为一服，重煮都成四服。疑非仲景方。

【词解】

分为三帖：帖，量词。分为三帖，即将上述药物组合后，分为三份。

如人行四五里进一服：指服药间隔时间，约每隔二十至三十分钟服药一次。

四体塞：即四肢壅肿之意。

【选注】

《金匱要略集注》：“案《素问·阴阳应象大论》云：冬伤于寒，春必病温；春伤于风，夏生飧泄；夏伤于暑，秋必痲症；秋伤于湿，冬生咳嗽。此皆四时不正之气，乘人五藏之虚而伤之，致邪伏于皮肤之里，藏府之外，三焦之募原，久则血凝气滞郁而为热，变证百出矣。仲景立此方，欲人为未雨之绸缪，以思患而预防之，乘邪之初集而攻之。夫四时风寒暑湿之邪虽不同，而伤之不即发，则郁于少阳一也。故用柴胡为君，引诸药直达三焦之膜原，一解散其五藏之寒热；寒热久者必有积滞，故用大腹槟榔、枳实以为臣；邪之所中其气必虚，故用白术以培中气。生姜以散胃寒；桔梗清上焦之郁热；腹皮消中焦之积湿。冬加柴胡以预解其温；春加枳实以早弭其泄；夏暑发于秋则为痲症，故加甘草以清血解毒；秋湿作于冬则成咳嗽，故加陈皮以利气宽胸。何一非杜渐防微之意乎？滓再合煮者，仍不离和解少阳之成法也。吴又可氏《瘟疫论》中之达原饮，盖即从本方化出耶。”

2.长服诃梨勒丸方疑非仲景方

诃梨勒 陈皮 厚朴各三两

上三味，末之，炼蜜丸如梧子大，酒饮服二十丸，加至三十丸。

【选注】

《金匱要略集注》：“案人之疾病由饮食不节，至肠胃积滞而成者，常十之八九。故古人养生方，长服多消导之药，所以使腠理无壅滞，九窍不闭塞而气血自调畅也。后人每喜用滋腻之品以为补益之方，至气壅邪滞，盖由未达此理也。本方三味皆利气行滞之物，蜜丸酒服，使血分之气，亦无滞也。”

3.三物备急丸方见《千金》司空裴秀为散用亦可。先和成汁，乃倾口中，令从齿间得入，至良验。

大黄一两 干姜一两 巴豆一两，去皮心，熬，外研如脂

上药各须精新，先捣大黄、干姜为末，研巴豆内中，合治一千杵，用为散，蜜和丸亦佳，密器中贮之，莫令歇。主心腹诸卒暴百病。若中恶客忤，心腹胀满，卒痛如锥刺，气急口噤，停尸卒死者，以暖水若酒服大豆许三四丸，或不下，捧头起，灌令下咽，须臾当差，如未差，更与三丸，当腹中鸣，即吐下便差。若口噤，亦须折齿灌之。

【词解】

中恶客忤：中恶，指感受恶寒气，又谓中邪恶鬼祟致病者。客忤，是指突然感受邪恶毒气，病势凶急，使人欲死。

停尸：丹波元简曰：“案停尸无考，盖是即遁尸。《巢源》云：遁尸者，言其停遁在人肌肉血脉之间，瘥后复发，停遁不消，故谓之遁尸也。”

【选注】

《医宗金鉴》：“方名备急者，以备暴然诸腹满，腹急痛及中恶客忤、噤闭卒死者也。若口噤亦须折齿灌之，是恐人不急救则死之义，然不如后人管吹入鼻中之法为良。李彰曰：人卒得病欲死者，皆感毒厉邪阴不正之气而然。三物相须，能荡邪安正，或吐或下，使秽气上下分消，诚足备一时急需也。”

《金匱要略论注》：“此方妙在干姜巴黄峻利，寒热俱行，有干姜以守中，则命蒂常存，且以通神明而复正性，故能治一切中恶卒死耳。”

4.治伤寒令愈不复，紫石英散方见《千金翼》。

紫石英 白石英 赤石脂 钟乳碓炼 栝楼根 防风 桔梗 文蛤 鬼臼各十分 太一余粮十分，烧 干姜 附子炮去皮 桂枝去皮，各四分
上十三味，杵为散，酒服方寸匕。

【词解】

令愈不复：指病愈后防止复发之意。

【选注】

《金匱要略集注》：“案伤寒大病后，余热遗毒蕴于骨髓血脉之中，每致精神昏愤，或为百合狐惑等证，或发为疮疡疹丹。此方取姜附桂防引诸五石等药，以搜其深藏之伏寒遗热，名寒食者盖即风引汤之变方也。”

5.救卒死方

薤捣汁，灌鼻中。

【选注】

《金匱要略集注》：“李珣臣曰：阴邪客气闭塞关窍，则猝然而死。薤味辛而属阳，可辟阴邪通阳气。然必捣汁灌鼻中者，以天气通于肺，肺主气，鼻为肺窍，司呼吸，使外邪自鼻而进者，仍令从鼻而出也。”

又方：

雄鸡冠割取血，管吹内鼻中。

【选注】

《医宗金鉴》：“雄鸡冠血及肝、卵白、猪脂、大豆、酒、醋等物，无非用阳物以胜阴崇也。管吹内鼻中，谓将鸡冠血或合热酒，含在不病人口内，以苇管或笔管插入病人鼻孔中，使气连药吹之，其药自能下咽，气通噤自开也。”

猪脂如鸡子大，苦酒一升煮沸灌喉中。

【选注】

《金匱要略集注》：“李珣臣曰：猪脂滑窍而助胃气；苦酒醋也。煮沸则香气扑鼻，灌之可敛正祛邪。”

鸡肝及血涂面上，以灰围四旁，立起。

【选注】

《金匱要略论注》：“凡人阳气一分不尽则不死，故救卒死唯以复其阳气为主。若鼻气通于天，天阳之所通也。口气通于地，地阳之所通也。面为诸阳之聚，属阳明中土，人阳之所通也……鸡属巽，肝为魂之主，涂面则内通于胃，以灰围四旁则气更束而内入，相引入肝，故肝气通而愈。”

大豆二七粒，以鸡子白并酒和，尽以吞之。

【选注】

《金匱要略论注》：“……苦酒为引，鸡子白能通肾中之阳，大豆为引，故以灌喉。”

6.救卒死而壮热者方

矾石半斤，以水一斗半煮消，以渍脚令没踝。

【选注】

《医宗金鉴》：“厥而身壮热者，阳厥府病也，外以矾水浸脚，盖以厥起于下，而收摄阳气也。程林曰：厥阳独行，故卒死而壮热。岐伯曰：血之与气，并走于上则为大厥，厥则暴死。矾石，收摄药也，以之浸足，而收敛其厥逆之气。”

7.救卒死而目闭者方

骑牛临面，捣薤汁灌耳中，吹皂荚末鼻中，立效。

【选注】

《金匱要略直解》：“葛洪肘后方治卒魘不寤，以青牛蹄或马蹄临人头上即活，则骑牛临面，系厌恶驱邪法也。目闭者，邪气内着也，灌薤汁以辟邪安魂，吹皂荚以取嚏开窍。”

8.救卒死而张口反折者方

灸手足两爪后十四壮了，饮以五毒诸膏散。有巴豆者。

【选注】

《金匱要略直解》：“灸手足两爪后，当是灸两手足爪后，其文则顺。以十爪甲为十二经之终始，灸之以接引阳气而回卒死，此恶气中于太阳，令卒死而开口反张也。五毒诸膏散方未见。”

9.救卒死而四肢不收失便者方

马屎一升，水三斗，煮取二斗以洗之；又取牛洞稀粪也一升，温酒灌口中，灸心下一寸、脐上三寸、脐下四寸各一百壮，差。

【选注】

《金匱要略直解》：“卒死而四肢不收者，无阳以行四末也。失便者，正气衰微不能约束便溺也。物之臭者皆能解毒杀邪，故以牛马粪及后条狗粪治之。心下一寸当是上脘穴；脐上三寸当是中脘穴；脐下四寸当是关元穴，灸之以复三焦之阳，而回其垂绝之气。”

10.救小儿卒死而吐利不知是何病方

狗屎一丸，绞取汁以灌之。无湿者，水煮干者取汁。

【选注】

《金匱要略论注》：“吐利非即死病，吐利而卒死又无他病可据，则知上吐下利病在中矣。狗性热善消物，粪乃已消之滓，病邪得之如其消化，类相感也。近有用狗粪以治膈噎，有用狗屎中骨末以治腹痛，百药不效而骨立欲死者，无不神验，可悟此理矣。”

11.尸魘脉动而无气，气闭不通，故静而死也，治方脉证见上卷。

菖蒲屑，内鼻两孔中吹之，令人以桂屑着舌下。

【词解】

尸魘：魘，即蹶。尸蹶，是指昏不知人而脉搏仍跳动，乃气息闭塞如尸之静而不动，故名之。

【选注】

《金匱要略直解》：“《甲乙經》曰：尸蹶者死不知人，脈動如故。《傷寒論》曰：尸蹶者令人不仁，即氣閉不通，靜而死之謂也。菖蒲內鼻中以通其肺氣；桂內舌下以開其心竅。心肺開則上焦之陽自能開發，尸厥之疾可愈。”

又方：

剔取左角發方寸燒末，酒和，灌令入喉，立起。

【選注】

《金匱要略直解》：“內經曰：邪客于手足少陰、太陰、足陽明之絡，此五絡皆會于耳中，上絡左角。五絡皆竭，令人身脈皆動而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥。以竹管吹其兩耳，剔其左角之發方一寸，燔治，飲以美酒一杯，不能飲者，灌之立已，見繆刺論。今仲景亦剔左角之發治者，以左角為陽氣之所在，五絡之所繞，五絡皆竭，故剔其五絡之血余以治之，和以酒灌者，助藥力而行氣血也。”

12.救卒死客忤死還魂湯主之方 《千金方》云：主卒忤鬼击飞尸，诸奄忽气绝，无复觉，或已无脉，口禁拗不开，去齿下汤。汤下口不下者，分病人发左右，捉^掄肩引之。药下复增取一升，须臾立苏。

麻黄三两，去节 一方四两 杏仁去皮尖，七十个 甘草一两，炙 《千金》用桂心二两

上三味，以水八升，煮取三升，去滓，分令咽之。通治诸感忤。

【選注】

《金匱要略論注》：“凡卒死及客忤死，总是正不胜邪，故阳气骤闭而死。肺朝百脉为一身之宗，麻黄、杏仁利肺通阳之君药，合炙草以调中，故为救卒死主方，名曰还魂汤，著其功也。”

《医宗金鉴》：“中恶客忤，便闭里实者，仲景用备急丸，可知无汗表实者，不当用备急丸通里，当用还魂汤以通表也。通里者，抑诸阴气也；通表者，扶诸阳气也。昧者不知，以麻黄为入太阳发汗之药，抑知不温复取汗，则为入太阴通阳之药也，阳气通动，魂可还矣。”

又方：

韭根一把 乌梅二七个 吴茱萸半升，炒

上三味，以水一斗煮之，以病人栝内中，三沸，栝浮者生，沉者死。煮取三升，去滓，分饮之。

【詞解】

栳：梳篦的总名，亦指旧时妇女的发饰。

【选注】

《金匱要略论注》：“韭根有薤白之功；乌梅有开关之力；吴茱萸能降浊阴。阴降而关开，则魂自还，故亦取之。然栳浮则生、沉则死，盖栳为本人日用之物，气之所及也，浮则其人阳气未绝，沉则久已有阴无阳，故主死。然仍分饮之，信栳无宁信药耳。”

13.救自缢死，旦至暮虽已冷，必可治；暮至旦，小难也，恐此当言忿气盛故也。然夏时夜短于昼，又热犹应可治。又云：心下若微温者，一日以上，犹可治之方。

徐徐抱解，不得截绳，上下安被卧之。一人以脚踏其两肩，手少挽其发常弦弦勿纵之；一人以手按据胸上，数动之；一人摩捋臂胫屈伸之，若已僵，但渐渐强屈之，并按其腹。如此一炊顷，气从口出，呼吸眼开，而犹引按莫置，亦勿若劳之，须臾，可少桂汤及粥清含与之，令濡喉，渐渐能咽，及稍止。若向令两人以管吹其两耳，采好。此法最善，无不活也。

【选注】

《医宗金鉴》：“旦至暮，阳气有余，阳主生，故虽已冷必可治也。暮至旦，阴气有余，阴主死，故稍难也。自缢之人，必可治者，恐此当有言语忿争，气盛不散，故可治也。暮至旦，固难治；然遇夏时夜短于昼又热，皆阳气有余，犹应可治。又云：心下若微温者，虽一日以上，犹可治之。观此谆谆告切，仲景仁心，惟恐人畏其繁琐而不治也。此法尝试之，十全八九，始知言果不谬。弦弦，犹言紧紧也。揉胸按腹，摩臂胫屈伸之，皆引导其气之法也。”

14.凡中喝死，不可使得冷，得冷便死，疗之方

屈草带，绕喝人脐，使三两人溺其中，令温。亦可用热泥和屈草，亦可扣瓦碗底按及车缸以着喝人，取令溺，须得流去，此谓道路穷，卒无汤，当令溺其中，欲使多人溺，取令温若汤，便可与之，不可泥及车缸，恐此物冷，喝既在夏月，得热泥土、暖车缸，亦可用也。

【词解】

车缸：是指车轴铁辖头。

【选注】

《金匱要略译释》：“夏月中暑昏仆而死，名叫中喝，多因身体虚

弱或饮食劳役失节及为暑热灼熏，客邪郁闭，关窍窒塞而然，不可以冷水冷物，由体外以作冷敷冷浴，致使客邪不得宣发，蕴积于内，寒热相激，反致下利。屈指溺脐，热泥车缸着脐，皆为温熨之法，因气海、关元等穴均在脐下，得热则阳通窍开而愈。”

15.救溺死方

取灶中灰两石余，以埋人，从头至足，水出七孔，即活。

上疗自缢溺喝之法，并出自张仲景为之，其意殊绝，殆非常情所及，本草所能关，实救人之大术矣。伤寒家数有喝病，非此遇热之喝。见《外台》、《肘后》目。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：灶灰得火土相生之气，以埋人则外温卫气，而内渗水湿，故能使水出七孔而活。”

16.治马坠及一切筋骨损方见《肘后》方

大黄一两，切浸，汤成下 绀帛如手大，烧灰 乱发如鸡子大，烧灰用 久用炊单布一尺，烧灰 败蒲一握三寸 桃仁四十九个，去皮尖熬 甘草如中指节，炙剉

上七味，以童子小便量多少煎汤成，内酒一大盞，次下大黄，去滓，分温三服。先剉败蒲席半领，煎汤浴，衣被盖复，斯须通利数行，痛楚立差。利及浴水赤，勿怪，即瘀血也。

【选注】

《金匱要略论注》：“从高坠下，虽当救损伤筋骨为主，然顿跌之势，内外之血必无不瘀，瘀不去则气不行，气不行则伤不愈，故以桃仁、大黄逐瘀为主；绀帛红花之余，乱发血之余，合童便以消瘀血；败蒲亦能破血行气，故入煎能疗腹中损伤瘀血，汤浴能活周身血气；然筋骨瘀血必有热气滞郁，故以炊单布受气最多而易消者以散滞通气，从其类也；加少炙甘草，补中以和诸药也。”

结语

本篇论述了十多种病证治方。其中救卒死证治方十二首；救尸蹶证治方二首，以及救溺死证、中喝死证、自缢死证治方各一首。上述危急重证治方的特点，是给药的途径各有不同，如有内服、口含、灌鼻、管吹内鼻中、管吹两耳、涂面、外熨、外浸等不同。其目的是根据不同的

发病机理，而捷取药效，速奏转危为安之功。在本篇中，还论述了加减柴胡饮子方以治五脏虚热；诃梨勒丸方治气壅邪滞于中之证；紫石寒食散方为伤寒令愈不复之治剂；三物备急丸治心腹诸卒暴百病、中恶客忤、气急口噤、停尸卒死等证，若属阳热证者，则忌用三物备急丸。

禽兽鱼虫禁忌并治第二十四

概说

本篇是论述禽兽鱼虫等动物类食品的饮食卫生，预防食物中毒和各种食物中毒治方。本篇共有条文一百零一条，载方二十一首。其中第一条是论禁忌不洁食物的原因和治疗方法。第二条是论五脏之病，有五味之禁忌，以及四时有宜食不宜食的规律。第三条至第十八条、第二十四条至第三十二条、第三十五条至第四十条、第四十三条至第五十七条、第五十九条至第七十二条、第七十四条至第九十二条、第九十七条、第九十九条至第一百零一条，是论各种不洁禽兽鱼虫类食物的辨别方法、食物中毒引起的各种疾病，以及某些食物相混饮用不利于健康的原理、妊娠饮食禁忌等。

其他十六条则论各种食物中毒的治法和方药。

本篇条文甚多，内容较为丰富，对于我们研究古人在饮食卫生方面的预防方法，以及饮食中毒的解毒治方功效是很有帮助的。

1.凡饮食滋味，以养于生，食之有妨，反能为害，自非服药炼液，焉能不饮食乎？切见时人，不闲调摄，疾疢竞起，若不因食而生，苟全其生，须知切忌者矣。所食之味，有与病相宜，有与身为害，若得宜则益体，害则成疾，以此致危，例皆难疗。凡煮药饮汁，以解毒者，虽云救急，不可热饮，诸毒病得热更甚，宜冷饮之。

【选注】

《金匱要略论注》：“凡气遇热则增，遇冷则减，毒气亦然，故曰诸毒病得热更甚。凡解毒药必甘寒之品，亦此故也。若干霍乱饮热汤则死，盖由邪热炽盛，故得热更甚，每见猪尿及盐水性寒，皆能愈之，亦所谓饮冷，不独汤之凉也，不宜辛热药亦可知也。”

2.肝病禁辛，心病禁咸，脾病禁酸，肺病禁苦，肾病禁甘；春不食肝，夏不食心，秋不食肺，冬不食肾，四季不食脾。辨曰：春不食肝者，为肝气王，脾气败，若食肝，则又补肝，脾气败尤甚，不可

救。又肝王之时，不可以死气入肝，恐伤魂也。若非王时即虚，以肝补之佳，余藏准此。

【选注】

《医宗金鉴》：“此言五藏有病，而禁之以五味何也？肝木病若与之以辛，辛助肺气，恐克肝也，故肝病则禁辛。心火病若与之以咸，咸能益水，恐水克火也，故心病则禁咸。脾土病若与之以酸，酸味属肝，恐木克土也，故脾病则禁酸。肺金病若与之以苦，苦味属火，恐克金也，故肺病则禁苦。肾水病若与之以甘，甘能补脾，脾主克水，故肾病则禁甘。”“此言四时，有宜食，有不宜食者。如春为肝王，则脾弱，故宜食脾，而不宜食肝，若食肝，则肝益王，而脾更弱，故曰：不可救。又云：肝王之时，不可以死气入肝，即《内经》毋伐天和之意。若伐天和，则伤肝，肝主魂，恐复伤魂也。若非王时，即虚，虚则以肝补肝，故谓之佳，余藏准此。”

3.凡肝脏自不可轻噉，自死者弥甚。

【选注】

《医宗金鉴》：“谓诸畜兽临杀之时，心有所惊，肝有所忿，食之俱不利，故曰：不可轻噉，如兽自死者，必中毒而死，更不可食也。”

4.凡心皆为神识所舍，勿食之，使人来生复其报对矣。

【选注】

《金匱要略直解》：“畜兽虽异于人，其心亦神识所舍，勿食之，生杀果报谅不诬也。”

5.凡肉及肝，落地不着尘土者，不可食之。猪肉落水浮者，不可食。

【选注】

《金匱要略直解》：“皆涉怪异，食之必有非常之害。下见水自动，热血不断，尘土不污，并同。”

6.诸肉及鱼，若狗不食，鸟不啄者，不可食。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡禽兽不食之肉，必有毒，不可食之。”

7.诸肉不干，火炙不动，见水自动者，不可食之。

【选注】

《金匱要略译释》：“此因异于寻常，恐其有害，故不可食之。”

8.肉中有如朱点者，不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“朱点恶血所聚，此色恶不食也。”

9.六畜肉热血不断者，不可食之。父母及身本命肉，食之令人神魂不安。

【选注】

《金匱要略直解》：“仁人孝子当自识之。”

10.食肥肉及热羹，不得饮冷水。

【选注】

《医宗金鉴》：“食肥肉热羹后，继饮冷水，冷热相搏，腻膈不行，不腹痛吐利，必成痞变积，慎之慎之。”

11.诸五藏及鱼，投地尘土不污者，不可食之。

【选注】

《千金翼方》：“凡六畜五藏著草自动摇，及得咸酢不变，自又坠地不污，又与犬犬不食者，皆有毒杀人。”

12.秽饭、馁肉、臭鱼，食之皆伤人。

【选注】

《金匱要略直解》：“物已败腐，必不宜于藏府，食之则能伤人，臭恶不食也。”

13.自死肉，口闭者，不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡自死之物，其肉皆有毒，口闭则毒不得外泄，切不可食。”

14.六畜自死，皆疫死，则有毒，不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“疫毒能死六畜，其肉必有疫毒，故不可食。”

15.兽自死，北首及伏地者，食之杀人。

【选注】

《金匱要略直解》：“首头向也，凡兽向杀方以自死及死不僵直，斜倒而伏地者，皆兽之有灵知，故食之杀人，《檀弓》曰：狐死正首丘，豹死首山。乐其生不忘本也，兽岂无灵知者耶。”

16.食生肉，饱饮乳，变成白虫。一作血蛊。

【选注】

《医宗金鉴》：“食生肉饱，即饮乳酪，则成湿热，必变生白虫。”

17.疫死牛肉，食之令病洞下，亦致坚积，宜利药下之。

【选注】

《医宗金鉴》：“疫死牛肉，有毒不可食，食之洞泻，为其毒自下，或致坚积，宜下药利之。”

18.脯脏米瓮中，有毒，及经夏食之，发肾病。

【选注】

《医宗金鉴》：“脯肉藏米瓮中，受湿热郁蒸之气，及经夏已腐者，食之腐气入肾，故发肾疾。”

19.治自死六畜肉中毒方

黄蘗屑，捣服方寸匕。

【选注】

《金匱要略直解》：“六畜自死必因毒疫，苦能解毒，黄蘗味之苦者。”

20.治食郁肉漏脯中毒方郁肉，密器盖之隔宿者是也。漏脯，茅屋漏下沾着者是也。

烧犬屎，酒服方寸匕，每服人乳汁亦良。饮生韭汁三升，亦得。

【选注】

《医宗金鉴》：“郁肉，密藏经宿之肉也。漏脯，经漏水之脯也。食之中毒，以烧犬屎、人乳汁、生韭汁，量其轻重而解之。”

21.治黍米中藏干脯食之中毒方

大豆，浓煮汁饮数升即解。亦治狸肉漏脯等毒。

【选注】

《金匱要略直解》：“肘后方云：此亦郁肉也，大豆能解诸毒，故用以治。”

22.治食生肉中毒方

掘地深三尺，取其下土三升，以水五升煮数沸，澄清汁，饮一升，即愈。

【选注】

《医宗金鉴》：“地浆能解诸毒，掘得黄土有泉渗出，谓之地浆。三尺，大概言也，未见黄土，皆秽土，得黄土乃可取用。”

23.治六畜鸟兽肝中毒方

水浸豆豉，绞取汁，服数升愈。

【选注】

《医宗金鉴》：“食禽肉兽肝，中毒在胃，故用豆豉涌吐其毒。”

24.马脚无夜眼者，不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡马皆有夜眼，若无者其形异，故勿食之。”

25.食酸马肉，不饮酒，则杀人。

【选注】

《医宗金鉴》：“马肉味酸有毒，故饮酒以解之。”

26.马肉不可热食，伤人心。

【选注】

《医宗金鉴》：“马属火，肉热火甚，恐伤心，当冷食之。”

27.马鞍下肉，食之杀人。

【选注】

《金匱要略直解》：“马鞍下肉多臭烂有毒，食之杀人。”

《医宗金鉴》：“鞍下肉，久经汗渍有毒，食之杀人。”

28.白马黑头者，不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“《食疗》云：食之令人癫。”

29.白马青蹄者，不可食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“虎鈴經曰：白馬青蹄皆馬之利害者，騎之不利人，若食之必能取害也。”

30.馬肉、獐肉共食，飽醉卧，大忌。

《醫宗金鑑》：“馬肉屬火，獐肉屬水，共食已屬不和，若醉飽即卧，則傷脾氣，故曰：大忌。”

31.驢、馬肉合猪肉食之，成霍亂。

【選注】

《醫宗金鑑》：“諸肉雜食，恐難消化，亂于腸胃，故成霍亂。”

32.馬肝及毛，不可妄食，中毒害人。

【選注】

《金匱要略直解》：“馬肝及毛皆有大毒，不可妄食。馬肝一名懸烽。”

33.治馬肝毒中人未死方

雄鼠屎二七粒，末之，水和服，日再服。尿尖者是。

【選注】

《金匱要略直解》：“馬稟火氣而生，火不能生水，故有肝無膽而木藏不足，故食其肝者死。漢武帝云：食肉無食馬肝。又云：文成食馬肝而死。韋莊云：食馬留肝，則其毒可知矣。馬食鼠屎則腹脹，故用鼠屎而治馬肝毒，以物性相制也。”

又方：

人垢，取方寸匕，服之佳。

【選注】

《金匱要略直解》：“人垢汗所結也，味咸有毒，亦以毒解毒之意。”

《金匱要略譯釋》：“人垢即頭髮灰垢，服之引吐以解毒。”

【選注】

34.治食馬肉中毒欲死方

香豉二兩 杏仁三兩

上二味，蒸一食頃熟，杵之服，日再服。

【选注】

《医宗金鉴》：“日华子云：黑豆调中下气，治牛马瘟毒，杏仁下气，气下则毒亦解矣。”

又方：

煮芦根汁饮之良。

【选注】

《医宗金鉴》：“芦根味甘性寒，解诸肉毒。”

35.疫死牛，或目赤，或黄，食之大忌。

【选注】

《金匱要略直解》：“牛疫死而目赤黄者，疫疠之毒不去也，食之大忌。”

36.牛肉共猪肉食之，必作寸白虫。

【选注】

《金匱要略直解》：“牛肉性滞，猪肉动风，入胃不消，酿成湿热则虫生也，亦有共食而不生虫者，视人之胃气何如耳。”

37.青牛肠，不可合犬肉食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“青牛，水牛也，其肠性温，犬肉性热，温热之物，不可合食。”

38.牛肺从三月至五月，其中有虫如马尾，割去勿食，食则损人。

【选注】

《金匱要略直解》：“春夏之交，湿热蒸郁，牛感草之湿热则虫生于胃，而缘入肺窍，故勿食之。”

39.牛、羊、猪肉，皆不得以楮木、桑木蒸炙，食之令人腹内生虫。

【选注】

《医宗金鉴》：“古人炼药多用桑柴火，楮实子能健脾消水，楮木亦可烧用，何以蒸炙诸肉食之即生虫乎？其或物性相反也。”

40.噉蛇牛肉杀人。何以知之？噉蛇者，毛发向后顺者是也。

【选注】

《诸病源候论》：“凡食牛肉有毒者，由毒蛇在草，牛食因误噉蛇则死，亦有蛇吐毒着草，牛食其草亦死，此牛肉有大毒。”

41.治噉蛇牛肉食之欲死方

饮人乳汁一升，立愈。

【选注】

《金匱要略直解》：“藏器曰：北人牛瘦多以蛇从鼻灌之，其肝则独，乳汁能解独肝牛肉毒。噉蛇牛，当是独肝牛也。”

又方：

以泔洗头，饮一升愈。

牛肚细切，以水一斗，煮取一升，暖饮之，大汗出者愈。

【选注】

《金匱要略直解》：“以泔洗头饮者，取头垢能吐所毒也。以牛肚煮服者，取其同类相亲，同气相求，大发其汗以出其毒也。”

42.治食牛肉中毒方

甘草煮汁饮之，即解。

【选注】

《医宗金鉴》：“甘草味甘，能解百毒。”

43.羊肉其有宿热者，不可食之。

【选注】

《金匱要略论注》：“宿热者，谓旧有热病人也。羊肉补气，得补而热增，故不可食。”

44.羊肉不可共生鱼、酪食之，害人。

【选注】

《金匱要略直解》：“生鱼，鲙之属；酪，乳之属。生鱼与酪食，尚成内瘕，加以羊肉食之，必不益也。”

45.羊蹄甲中有珠子白者，名羊悬筋，食之令人癡。

【选注】

《医宗金鉴》：“此义未详。”

46.白羊黑头，食其脑，作肠痈。

【选注】

《金匱要略直解》：“羊脑有毒，食之发风疾，损精气，不唯作肠痈也。方书只用为外敷药。”

47.羊肝共生椒食之，破人五藏。

【选注】

《医宗金鉴》：“羊肝，生椒皆属于火，共食恐损伤人五藏也。”

48.猪肉共羊肝和食之，令人心闷。

【选注】

《医宗金鉴》：“猪肉滞，羊肝腻，共食则气滞而心闷矣。”

49.猪肉以生胡荽同食，烂人脐。

【选注】

《金匱要略直解》：“胡荽损精神，发痼疾；猪肉令人乏气少精，发痼疾，宜其不可共食。若烂脐，则不可解。”

50.猪脂不可合梅子食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“猪脂滑利，梅子酸涩，性相反也，故不可合食。”

51.猪肉和葵食之，少气。

【选注】

《金匱要略直解》：“葵性冷利，生痰动风，猪肉令人乏气，合食之非止于少气也。”

52.鹿人不可和蒲白作羹，食之发恶疮。

【选注】

《金匱要略直解》：“鹿肉九月已后至正月已前堪食，他月食之则发冷痛。蒲白想是蒲筍之类，当详之。”

53.麋脂及梅李子，若妊妇食之，令子青盲，男子伤精。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：人目以阴为体，以阳为用。麋，阴兽也，梅及李味酸苦，亦属阴类，孕妇三物合食，则阴气太盛，阳气绝

少，故令子青盲也。男子精气宜温暖，阴盛则精寒。《本草》云：麋脂令阴痿。”

54.麋肉不可合虾及生菜、梅、李果食之，皆病人。

【选注】

《金匱要略直解》：“麋肉十二月至七月食之动气，虾能动风热，生菜梅李动痰，合食之皆令人病。”

《医宗金鉴》：“麋肉性温，八月至十一月食之胜羊肉，余月食之动气。”

55.痼疾人不可食熊肉，令终身不愈。

【选注】

《医宗金鉴》：“人有痼疾，不可食熊肉，因熊性强悍，食之痼疾永不除。”

56.白犬自死，不出舌者，食之害人。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡犬死必吐舌，惟中毒而死，其舌不吐，毒在内也，故食之害人。”

57.食狗鼠余，令人发痿疮。

【选注】

《金匱要略直解》：“余，狗鼠之剩食也。其涎毒在食中，人食之则毒散于筋络，令发痿疮。”

58.治食犬肉不消，心下坚，或腹胀，口干大渴，心急发热，妄语如狂，或洞下方。

杏仁一升，合皮熟研用

以沸汤三升，和取汁，分三服，利下肉片，大验。

【选注】

《金匱要略直解》：“犬肉畏杏仁，故能治大肉不消，近人以之治狂犬咬，皆此意。”

59.妇人妊娠，不可食兔肉、山羊肉，及鳖、鸡、鸭，令子无声音。

【选注】

《金匱要略直解》：“妊娠食兔肉，則令子缺唇；食羊肉，則令子多熱；食鰲肉，則令子項短，又令無聲音也；若食犬肉，則令子無聲音，雞鴨肉胎產需以補益，二者不必忌之。”

60.兔肉不可合白雞肉食之，令人面發黃。

【選注】

《醫宗金鑑》：“兔肉酸寒，多食損元氣，絕血脈，令人萎黃。白雞雖得庚金太白之象，實屬風木，能助肝火。二物合食，動脾氣而發黃，故不可合食。”

61.兔肉着干姜食之，成霍亂。

【選注】

《醫宗金鑑》：“兔肉酸寒，陰性也，干姜辛熱，陽性也，性味相反，同食者必成霍亂。”

62.凡鳥自死，口不閉，翅不合者，不可食之。

【選注】

《金匱要略直解》：“鳥自死必斂翅閉口，若張翅開口，其死也異，其肉也必毒，不可食之。”

63.諸禽肉，肝青者，食之殺人。

【選注】

《金匱要略直解》：“青者必毒物所傷，故食之能殺人。”

64.雞有六翮四距者，不可食之。

【選注】

《醫宗金鑑》：“距，雞腳爪也。形有怪異者，有毒，故不可食。”

65.烏雞白首者，不可食之。

【選注】

《醫宗金鑑》：“色有不相合者，有毒，不可食。”

66.雞不可共葫蒜食之，滯氣。一云：雞子。

【選注】

《金匱要略直解》：“雞能動風，蒜能動痰，風痰發動則氣壅滯。”

67.山雞不可合鳥獸肉食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“山鸡，鸚鸡也，小于雉而尾长，人多畜之樊中。性食虫蚁而有毒，非唯不可共鸟兽肉司食，即单食亦在所忌也。”

68.雉肉久食之，令人瘦。

【选注】

《金匱要略直解》：“雉肉有小毒，发疮疥，生诸虫，以此则令人瘦。”

69.鸭卵不可合鳖肉食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“鸭卵性寒发冷气，鳖肉性冷亦发冷气，不可合食。”

70.妇人妊娠，食雀肉，令子淫乱无耻。

【选注】

《金匱要略直解》：“雀性最淫，周书云季秋入大水为蛤，雀不入水，国多淫佚，物类相感，理所必然。妊娠当戒食之。古慎胎教也。”

71.雀肉不可合李子食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“雀肉性暖大温，李子性寒味酸，温得寒酸而滞气，故不可合食。”

72.燕肉勿食，入水为蛟龙所噉。

【选注】

《医宗金鉴》：“蛟龙嗜燕，人食燕者，不可入水。雷公曰：海竭江枯，投游波而立泛，以蛟龙嗜燕故也。凡渡江海者，切不可食燕肉。”

73.鸟兽有中毒箭死者，其肉有毒，解之方。

大豆，煮汁及盐汁服之解。

【选注】

《金匱要略直解》：“箭药多是射罔毒，射罔乃乌头所熬，大豆汁能解乌头毒故也；咸能胜热，故盐亦解其毒。”

74.鱼头正白如连珠至脊上，食之杀人。

75.鱼头中无腮者，不可食之，杀人。

76.鱼无肠胆者，不可食之，三年阴不起，女子绝生。

77.鱼头似有角者，不可食之。

鱼目合者，不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“以上皆怪异之形色，必有毒也。”

78.六甲日，勿食鳞甲之物。

【选注】

《医宗金鉴》：“六甲值日，食鳞甲物犯其所忌，故曰勿食。”

79.鱼不可合鸡肉食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“鱼属火，善动；鸡属木，生风，风火相煽，故勿合食。”

80.鱼不得合鸬鹚肉食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“鸬鹚食鱼，物相制而相犯也，不可合食。”

81.鲤鱼鲐，不可合小豆藿食之；其子不可合猪肝食之，害人。

【选注】

《金匱要略直解》：“鲤鱼鲐、小豆藿味皆咸，咸能胜血，故陶弘景云：合食成消渴，其子合猪肝食伤人神。”

《医宗金鉴》：“小豆藿即小豆叶也。”

82.鲤鱼不可合犬肉食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“鲤鱼犬肉俱令热中，不可合食。”

83.鲫鱼不可合猴雉肉食之。一云不可合猪肝食。

【选注】

《金匱要略直解》：“鲫鱼同猴雉肉猪肝食，生痈疽。”

84.鯪鱼合鹿肉生食，令人筋甲缩。

【选注】

《金匱要略直解》：“鯢鱼，鲇鱼也。鯢鱼鹿肉皆能治风，生食反伤其筋脉，致令筋甲缩。”

85.青鱼鲙，不可合生葫荑及生葵并麦中食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“青鱼鲙不益人，葫荑生葵能动风发痼疾，必与青鱼鲙不相宜，鲙味咸麦酱亦咸，合食必作消渴。”

86.𩚑𩚑不可合白犬血食之。

《金匱要略直解》：“𩚑𩚑为无鳞鱼，白犬血为地厌，非唯不可合食，抑卫生家所当忌也。又𩚑𩚑善窜能动风，白犬血性热能动火，是不可合食。”

87.龟肉不可合酒果子食之。

【选注】

【选注】

《金匱要略直解》：“仲景以龟肉忌酒果子，而苏恭以龟肉酿酒治大风。陶弘景曰：龟多神灵，人不可轻杀，更不可轻噉也。果子亦不知何果。”

88.鳖目凹陷者，及厌下有王字形者，不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“龟无耳，以目为听，目凹陷，及腹中有王字形者，皆有毒，慎之。性与鸡鸭相反，故不可合食。”

89.其肉不得合鸡、鸭子食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“鳖肉令人患水，鸡子令人动风，鸭子令人气短，不可合食。”

90.龟、鳖肉不可合苋菜食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“龟鳖皆与苋菜相反，若合食之，必成鳖瘕。”

91.虾无须，及腹下通黑，煮之反白者，不可食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“无须失虾之形，腹黑必虾之毒，色白反虾之色，物既反常，必不可食。”

92.食脍，饮乳酪，令人腹中生虫为瘕。

【选注】

《医宗金鉴》：“脍乃牛、羊、鱼之腥，聂而切之为脍，乳酪酸寒，与脍同食则生虫为瘕，故戒合食。”

93.鲙食之，在心胸间不化，吐复不出，速下除之，久成癥病，治之方

橘皮一两 大黄一两 朴硝二两

上三味，以水一大升，煮至小升，顿服即消。

【选注】

《金匱要略直解》：“鲙，乃生鱼所作。橘皮能解鱼毒；消黄能下癥瘕。”

94.食鲙多不消，结为癥病，治之方

马鞭草

上一味，捣汁饮之。或以姜叶汁饮之一升，亦消。又可服吐药吐之。

【选注】

《医宗金鉴》：“马鞭草主治癥癖血瘕，破血杀虫，姜叶解毒，皆可用之。”

95.食鱼后食毒，两种烦乱，治之方

橘皮

浓煎汁服之，即解。

【选注】

《金匱要略直解》：“神農經曰：橘皮主胸中瘕熱逆氣，通神明，魚毒食毒俱可解。”

96.食鯀鯪魚中毒方

芦根

煮汁服之，即解。

【選注】

《醫宗金鑑》：“鯀鯪即河豚魚，味美其腹腴，呼為西施乳。頭無腮，身無鱗，其肝毒，血殺人，脂令舌麻，子令腹脹，眼令目花，惟芦根汁能解之。”

97.蟹目相向，足斑目赤者，不可食之。

【選注】

《金匱要略直解》：“蟹骨眼而相背，相向者其蟹異，足斑目赤者共蟹毒，故不可食。”

98.食蟹中毒治之方

紫蘇

煮汁飲之三升。紫蘇子搗汁飲之，亦良。

又方：

冬瓜汁飲二升，食冬瓜亦可。

【選注】

《醫宗金鑑》：“紫蘇、冬瓜，俱能解蟹毒，故用之。”

99.凡蟹未遇霜，多毒，其熟者乃可食之。

【選注】

《金匱要略直解》：“未遇霜者，霜降節前也。節前食水茭苳，故有毒；霜降節後食稻將蟄，則熟而味美，乃可食也。茭苳生水濱，有大

毒。”

100.蜘蛛落食中，有毒，勿食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“蜘蛛有毒，落食中或有尿，有丝粘食上，故不可食。”

101.凡蜂、蝇、虫、蚁等多集食上，食之致痿。

【选注】

《金匱要略直解》：“蜂蝇虫蚁禀湿热而有毒，集食上而人食之。湿热之毒传于肌肉，致生痿疮。”

结语

本篇论述了饮食卫生方面的知识，说明马、牛、羊、鸡、犬、猪、鱼等禽兽类食品，虽是美味之品，而且补养人体。但是，这是动物如果因误食毒品，感受疫毒等原因死亡的，又有某些动物本身内含毒素，或其形状畸形，或腐败变质的，若误食之，均可导致人体中毒。本篇强调了饮食卫生对人体健康的重要性，阐述了饮食对于疾病的影响，以及妊娠、病者的饮食禁忌。同时亦指出食品有寒热等属性的不同，在烹调和饮食时要调配得当，否则，食之对人体也有影响。

本篇重点地论述了肉类食品有毒无毒的辨别方法，以及误食各种有毒的肉类食品后，引起中毒的治疗方药。并指出服解毒方之时，不可乘热而饮，这是因为中毒之邪，其邪多属热性，热饮必助其势，故宜冷后服用。

本篇治疗食物中毒诸方药，是中医抢救食物中毒的宝贵遗产，可供研究和临床应用。

果实菜谷禁忌并治第二十五

概说

本篇是论述果实菜谷等植物类食品的饮食卫生，以及预防和治疗果实菜谷等食品中毒的方法和方药。本篇共有条文八十八条，载方十四首。其中第一条至第十四条、第二十一条至第五十六条、第六十二条至第八十条，是论上述食品的饮食卫生，阐述了这些不洁食品的辨别方法，指出某些食品混合饮用不利于健康的原理，以及春夏秋冬四季饮食和病者妊娠饮食的禁忌等。第八十三条至八十七条，是论矾石、商陆、葶苈、水银、苦楝等药物，用之不当引起的中毒症状。第十五条、第十七条至二十条、第五十七条至第六十一条、第八十一、八十二、八十八条则论误食各种不洁植物类食品而引起中毒的治疗方法和方药。

本篇条文亦多，内容也较丰富，结合上篇内容，对于探讨古人在饮食卫生方面的思想和预防治疗食物中毒的方法和药物，指导临床实践是有益处的。

1. 果子生食生疮。

【选注】

《金匱要略直解》：“诸果之实，皆成于夏秋，禀湿热之性，食之故令生疮。”

《医宗金鉴》：“果生之性，多湿多热而有毒，或生食之，故令生疮，腹胀作泄。”

2. 果子落地经宿，虫蚁食之者，人大忌食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡果落地，隔夜尚不可食，而况虫蚁食者乎？见之者切不可食。”

3. 生米停留多日有损处，食之伤人。

【选注】

《医宗金鉴》：“凡食之物停留多日，或隔夜者，若有损处，即虫鼠所吃之余，皆有毒伤人。”

4.桃子多食，令人热，仍不得入水浴，令人病淋沥寒热病。

【选注】

《金匱要略直解》：“桃实酸甘辛，生于春则味酸，成于夏则酸甘，成于秋则酸辛，其性热，故多食令人热也。若多食而入水浴，则酸味不得内泄，多令人癰，水寒之气因而外客，故令人寒热也。”

5.杏酪不熟伤人。

【选注】

《金匱要略直解》：“古人杏酪以酒蜜酿成，亦有甘草生姜汁熬成者，以杏仁有毒，半生半熟皆能害人也，今人另有制法。”

6.梅多食坏人齿。

【选注】

《金匱要略直解》：“梅实能致津液，津液出则骨伤，以肾主五液，齿为肾之标故也。”

7.李不可多食，令人胬胀。

【词解】

胬胀：胬，指腹前肉，胬胀则指腹部胀满而言。

【选注】

《医宗金鉴》：“李味酸涩，若多食，则脉中气不舒，故令人腹胀。”

8.林檎不可多食，令人百脉弱。

【选注】

《金匱要略直解》：“林檎酸涩而闭百脉，故多食令人百脉弱。”

9.橘柚多食，令人口爽，不知五味。

【选注】

《金匱要略直解》：“橘柚味酸，能恋膈生痰、聚饮，饮聚膈上则令人口淡不知味。”

《金匱玉函要略輯義》：“案時珍云：橘皮下氣消痰，其肉生痰聚飲，表里之異如此。程注本之，但爽字未妥，《爾雅釋言》：爽，差也，忒也。《老子》五味令人口爽，乃為口失味之義。”

10.梨不可多食，令人寒中，金瘡、產婦，亦不宜食。

【選注】

《金匱要略直解》：“梨性大寒，故令人寒中，寒能凝血脈，故金瘡產婦不宜食。”

11.櫻桃、杏，多食傷筋骨。

【選注】

《醫宗金鑑》：“櫻桃、杏味酸性寒，若過食則傷筋骨。《內經》云：酸則傷筋。寒主傷腎，故傷筋骨。”

12.安石榴不可多食，損人肺。

【選注】

《醫宗金鑑》：“安石榴味酸澀，酸澀則氣滯，肺主氣，宜利而不宜滯，滯則傷損矣，故不可過食也。”

13.胡桃不可多食，令人動痰飲。

【選注】

《金匱要略直解》：“胡桃能潤肺消痰，今令人動痰飲，何也？以胡桃性熱，多食則煎熬津液而為痰飲矣。”

14.生棗多食，令人熱渴氣脹，寒熱羸瘦者，彌不可食，傷人。

【選注】

《金匱要略直解》：“生棗味甘辛氣熱，以辛熱則令人渴；甘則令人氣脹也。羸弱者內熱必盛，而脾胃必虛，故彌不可食。”

15.食諸果中毒治之方

猪骨烧过

上一味，末之，水服方寸匕。亦治马肝、漏脯等毒。

【選注】

《医宗金鉴》：“以猪骨治果子毒，物性相制使然。治马肝毒者，以猪畜属水，马畜属火，此水克火之义也。治漏脯毒者亦骨肉相感之义耳。”

16.木耳赤色及仰生者，勿食。菌仰卷及赤色者，不可食。

【选注】

《金匱要略直解》：“木耳诸菌皆复卷，仰卷则变异，色赤则有毒，故不可食。”

17.食诸菌中毒，闷乱欲死，治之方

人粪汁饮一升，土浆饮一升，大豆浓汁煮饮之，服诸吐利药，并解。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：闷乱欲死，毒在胃也，服吐、利药并解，使毒气上下分消也。”

18.食枫柱菌而哭不止，治之以前方。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：心主笑，笑不止，是毒气入心也。以前方治之则解耳。”

19.误食野芋，烦毒欲死，治之以前方。其野芋根，山东人名魁芋，人种芋三年不收，亦成野芋，并杀人。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：烦出于肺，烦乱欲死，故知毒气入肺也，亦用前方。”

20.蜀椒闭口者有毒，误食之，戟人咽喉，气病欲绝，或吐下白沫，身体痹冷，急治之方

肉桂煎汁饮之，多饮冷水一二升，或食蒜，或饮地浆，或浓煮豉汁饮之，并解。

【选注】

《金匱要略直解》：“蜀椒气大热有毒，味辛麻，闭口者毒更甚。辛则戟人咽喉，麻则令人吐下白沫，身体痹冷也。冷水、地浆、豉汁，寒凉能解热毒。其桂蒜大热，而肘后诸方亦云解椒毒，不知其义，岂因其气欲绝，身体冷痹而用耶。”

《医宗金鉴》：“.....如桂与蒜，皆大辛大热之物，通血脉辟邪秽，以热治热，是从治之法也。冷水清凉解热，地浆得土气，以万物本乎土，亦莫不复归于土，见土则毒已化矣。饮豉汁者，吐以去其毒也。”

21.正月勿食生葱，令人面生游风。

【选注】

《金匱要略直解》：“正月甲木始生，人气始发，葱能走头面而通阳气，反引风邪而病头面，故令生游风。”

22.二月勿食蓼，伤人肾。

【选注】

《医宗金鉴》：“蓼味辛散，辛能走肾，二月卯木主令，肾主闭藏，若食之则伤肾，故曰：勿食。”

23.三月勿食小蒜，伤人志性。

【选注】

《金匱要略直解》：“小蒜辛热有毒，三月为阳气长养之时，不可食此夺气伤神之物。”

24.四月、八月勿食胡荽，伤人神。

【选注】

《金匱要略直解》：“胡荽葷菜也，辛芳之气损人精神，四月心火正王，八月肺将敛，以心藏神而肺藏魄，食此走散之物必能伤神也。”

25.五月勿食韭，令人乏气力。

【选注】

《金匱要略直解》：“韭菜春食则香，夏食则臭（出寇宗奭）。脾恶臭而主四肢，是以令人乏气力。”

26.五月五日勿食一切生菜，发百病。

【选注】

《金匱要略直解》：“五月五日为天中节，为纯阳日，人当养阳以顺令节，若食生菜则伐天和，故生百病。”

27.六月、七月勿食茱萸，伤神气。

【选注】

《金匱要略直解》：“六七月阳气尽发，吴茱萸辛热，辛能走气，故伤神气。”

28.八月、九月勿食姜，伤人神。

【选注】

《医宗金鉴》：“姜性热，味辛辣，八九两月，秋主收敛，过于辛散，故伤人之神。朱子晦庵云：秋食姜，夭人天年，谓其辛走气泻肺也。”

29.十月勿食椒，损人心，伤心脉。

【选注】

《金匱要略直解》：“《内经》曰：九月十月人气在心，椒能走气伤心，故伤心脉。”

30.十一月、十二月勿食薤，令人多涕唾。

【选注】

《金匱要略直解》：“薤白气味冷滑，能引涕唾，非独十一月、十二月然也。”

31.四季勿食生葵，令人饮食不化，发百病，非但食中，药中皆不可用，深宜慎之。

【选注】

《金匱要略直解》：“脾王四季，生葵冷滑非脾所宜，发病之物，药饵中皆不宜也。”

32.时病差未健，食生菜，手足必肿。

【选注】

《金匱要略直解》：“时病，热病也。热病新差而脾胃尚弱，食生菜则伤脾，故令手足浮肿。”

33.夜食生菜，不利人。

【选注】

《金匱要略直解》：“夜食生菜，则易停留而难转化，不利于人也。”

34.十月勿食被霜生菜，令人面无光，目涩心痛，腰疼，或发心症，症发时，手足十指爪皆青，困委。

【选注】

《金匱要略直解》：“道藏云：六阴之月万物至此归根复命，以待来复，不可食寒冷以伐天和。生菜性冷，经霜则寒，寒冷之物能损阳气，食之能发上证。”

35.葱、韭初生芽者，食之伤人心气。

【选注】

《金匱要略直解》：“萌芽含抑郁之气未伸，食之能伤心气。”

《金匱要略译释》：“本草宗奭曰：葱主发散，多食昏人神。”

36.饮白酒食生韭，令人病增。

【选注】

《医宗金鉴》：“酒多湿，韭性热，湿热相合，令人病增。”

37.生葱不可共蜜食之，杀人。独颗蒜，弥忌。

【选注】

《金匱要略直解》：“孙真人曰：葱同蜜食令人利下，独蒜气味辛臭，与蜜更不宜也。”

38.枣合生葱食之，令人病。

【选注】

《金匱要略直解》：“枣与葱食，令人五脏不和。”

39.生葱和雄鸡、雉、白犬肉食之，令人七窍经年流血。

【选注】

《医宗金鉴》：“李昉曰：此皆生风发火之物，若合食则血气更淖溢不和，故七窍流血。”

40.食糖、蜜后四日内食生葱、韭，令人心痛。

【选注】

《金匱要略直解》：“蜜与葱韭蒜皆相反，虽食蜜后四日内尤忌之，相犯乃令人心痛。”

41.夜食诸姜、蒜、葱等，伤人心。

【选注】

《金匱要略直解》：“人之气昼行于阳，而夜行于阴，夜食辛物以

扰乎阳，则伤上焦心隔之阳气也。”

42.芜菁根，多食令人气胀。

【选注】

《金匱要略直解》：“芜菁即蔓菁也，多食动气。（出寇宗奭）”

《医宗金鉴》：“此言不可过食，若过食则动气而胀也。”

43.薤不可共牛肉作羹，食之成瘕病，韭亦然。

【选注】

《金匱要略直解》：“薤韭牛肉皆难剋化之物，积而不消，则为瘕瘕。”

44.蓴多病，动痔疾。

【选注】

《医宗金鉴》：“蓴性滑有毒，滑而易下，故发痔病。”

《金匱要略译释》：“蓴音纯，蔬类植物，江浙湖泽中，产生最多，菜椭圆形，有长柄，浮于水面，嫩者可食，《别录》列为下品。”

45.野苳不可同蜜食之，作内痔。

【选注】

《金匱要略直解》：“野苳，苦**蕒**也。性苦寒能治痔，与蜜同食，复生内痔，物性相忌，则易其性也。”

46.白苳不可共酪同食，作**蠹**虫。

【选注】

《金匱要略直解》：“白苳苦寒，乳酪甘寒，合食停于胃中则生蚀**蠹**。”

47.黄瓜食之，发热病。

【选注】

《金匱要略直解》：“黄瓜动寒热，虚热天行热病后，皆不可食。（本孟诜）”

48.葵心不可食，伤人；叶尤冷，黄背赤茎者，勿食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“葵心有毒，背叶反常亦有毒，不可食。”

49.胡荽久食之，令人多忘。

【选注】

《医宗金鉴》：“胡荽辛温开窍，久食耗心血，故令人多忘。”

50.病人不可食胡荽及黄花菜。

【选注】

《医宗金鉴》：“胡荽耗气，黄花菜破气耗血，皆病人忌食。”

51.芋不可多食，动病。

【选注】

《医宗金鉴》：“芋滞有毒，多食则脾困而胀生，故戒多食。”

52.妊妇食姜，令子余指。

【选注】

《医宗金鉴》：“余指，手多一指也。姜形类指，物性相感如此。”

53.蓼多食，发心痛。

【选注】

《金匱要略直解》：“孙真人曰：黄帝云，食蓼过多有毒发心痛，以气味辛温故也。”

54.蓼和生鱼食之，令人夺气，阴咳疼痛。

【选注】

《医宗金鉴》：“生鱼鲙属合食，则相犯夺气也。阴核痛，亦湿热致病耳。”

55.芥菜不可共兔肉食之，成恶邪病。

【选注】

《金匱要略直解》：“芥菜昏人眼目，兔肉伤人神气，合食必为恶邪之病。”

56.小蒜多食，伤人心力。

【选注】

《金匱要略直解》：“小蒜辛温有小毒发痼疾，多食气散则伤心力。”

57.食躁或躁方

豉

浓煮汁饮之。

【选注】

《医宗金鉴》：“食躁或躁者，即今之食后时或恶心，欲吐不吐之病也，故以豉汤吐之。”

58.钩吻与芹菜相似，误食之杀人，解之方。《肘后》云：与茱萸食芹相似。

荠苳八两

上一味，水六升，煮取二升，分温二服。钩吻生地傍无他草，其茎有毛，以此别之。

【选注】

《医宗金鉴》：“太阴之精，名曰钩吻，入口则死。葛洪云：钩吻生处，无他草，茎上有毛。”

《金匱要略译释》：“按：钩吻即水莽草，与芹菜相似，有大毒。荠苳即甜桔梗，能解钩吻之毒。”

59.菜中有水茛菪，叶圆而光，有毒，误食之，令人狂乱，状如中风，或吐血，治之方

甘草

煮汁服之，即解。

【选注】

《金匱要略直解》：“荠苳、甘草解百药毒。”

60.春秋二时，龙带精入芹菜中，人偶食之为病。发时手背腹满，

痛不可忍，各蛟龙病治之方

硬糖二三升

上一味，日两度服之，吐出如蜥蜴三五枚，差。

【选注】

《金匱要略直解》：“芹菜生江湖陂泽之涯，蛟龙虽云变化莫测，其精那能入此，大抵是蜥蜴虺蛇之类，春夏之交遗精于此故耳。且蛇嗜芹，尤为可证。案《外台秘要》云：蛟龙子生在芹菜上，食之入腹变成龙子，须慎之。饴粳米杏仁乳饼煮粥食之，吐出蛟子大验。仲景用硬糖治之，余考之《本草》并无硬糖，当是粳米饴糖，无疑。二物味甘，甘能解毒故也。”

《金匱玉函要略辑义》：“刘熙释名云：饴之清者曰饴，形怡怡然也；稠者曰饴，强硬如饴也。时珍云：古人寒食多食饴，故医方亦收用之。明硬糖即是饴，程注殆妄矣。”

61.食苦瓠中毒治之方

黎穰

煮汁，数服之，解。

【选注】

《医宗金鉴》：“《风俗通》云：烧穰可以杀瓠。又云：种瓜之家不烧漆，物性相畏有如是也。人过食苦瓠，吐利不止者，以黍穰汁解之，本诸此。”

《金匱要略译释》：“苦瓠即苦菜，黎穰即黍茎。”

62.扁豆，寒热者不可食之。

【选注】

《医宗金鉴》：“扁豆性滞而补，如患寒热者忌之。”

63.久食小豆，令人枯燥。

【选注】

《金匱要略直解》：“小豆逐津液，利小便，津液消滅，故令肌肤枯燥。”

64.食大豆屑，忌噉猪肉。

【选注】

《金匱要略直解》：“大豆壅气，猪肉滞膈，故忌之，小儿十岁以下尤忌。”

65.大麦久食，令人作癰。

《医宗金鉴》：“李彣曰：癰疥同，盖麦入心，久食则心气盛而内热。《内经》曰：诸疮疡皆属心火，故作癰。”

【选注】

66.白黍米不可同饴蜜食，亦不可合葵食之。

【选注】

《金匱要略直解》：“黍米令人烦热，饴蜜令人中满，故不可同食。黍米合葵食成痼疾，亦不可合食。”

67.荞麦面多食之，令人发落。

【选注】

《金匱玉函要略辑义》：“案本纲荞麦，一名苽（音翹）麦。《千金》、《黄帝》云：荞麦作𪎭和猪羊肉热食之，还过八九，顿作热风，令人眉须落，又还生仍希少，泾邠已北，多患此疾。今荞麦𪎭，人多食之，未有发落者，此必脱和猪羊肉等字，程、《金鉴》并云：苽字有误，当详之，盖失考耳。”

68.盐多食，伤人肺。

【选注】

《金匱要略直解》：“盐味咸能伤肾，又伤肺，多食发哮喘，为终身痼疾也。”

69.食冷物，冰人齿。食热食，勿饮冷水。

【选注】

《医宗金鉴》：“寒热相搏，脾胃乃伤。”

70.饮酒，食生苍耳，令人心痛。

【选注】

《医宗金鉴》：“酒性纯阳，苍耳味苦有毒，苦先入心，饮酒以行其毒，故心痛。”

71.夏月大醉汗流，不得冷水洗着身，及使扇，即成病。

【选注】

《金匱要略直解》：“夏月大醉，汗流，浴冷水即成黄汗。扇取凉，即成漏风。”

72.饮酒大忌灸腹背，令人肠结。

【选注】

《金匱要略直解》：“毋灸大醉人，此灸家所必避忌也。”

73.醉后勿饱食，发寒热。

【选注】

《医宗金鉴》：“醉则肝、胆之气肆行，木来侮土，故曰：勿食饱，发寒热。”

74.饮酒食猪肉，卧秫稻穰中，则发黄。

【选注】

《金匱要略直解》：“饮酒而食肉则腠理开，卧稻穰中则湿热入，是以发黄也。”

75.食饴，多饮酒大忌。

【选注】

《医宗金鉴》：“谚云：酒家忌甘，此义未详。”

76.凡水及酒，照见人影动者，不可饮之。

【选注】

《金匱要略直解》：“此涉怪异，宜不可饮。”

77.醋合酪食之，令人血瘕。

【选注】

《金匱要略直解》：“醋酸敛而酪粘滞，令作血瘕。”

78.食白米粥，勿食生苍耳，成走疰。

【选注】

《金匱要略直解》：“白米粥能利小便，苍耳子能搜风，小便利而食搜风之物虚其经络，反致走注疼痛。”

《诸病源候论》：“走注候：注者，住也。言其病连滞停住死，又注易傍人也。人体虚受邪气，邪气随血而行，或淫奕皮肤，去来击痛，游走无有常所，故名走注。”

79.食甜粥已，食盐即吐。

【选注】

《金匱要略直解》：“甘者令人中满，食甜物必泥于膈上，随食以盐，得咸则涌泄也。”

80.犀角筋搅饮食，沫出，及浇地坟起者，食之杀人。

【选注】

《医宗金鉴》：“《抱朴子》云：犀食百草及众木之棘。故知饮食之毒，若搅饮食沫出者，必有毒也。浇地坟起者，此怪异也，故食之杀人。”

81.饮食中毒，烦满，治之方

苦参三两 苦酒一升半

上二味，煮三沸，三上、三下服之，吐食出即差。或以水煮亦得。

【选注】

《医宗金鉴》：“苦参味苦，苦酒味酸，酸苦涌泄而去其毒，烦满自除。”

又方：

犀角汤亦佳。

【选注】

《医宗金鉴》：“中毒烦满，毒在胃中，犀角解胃中毒。”

82.贪食，食多不消，心腹坚满痛，治之方

盐一升 水三升

上二味，煮令盐消，分三服，当吐出食，便差。

【选注】

《医宗金鉴》：“盐咸能软坚，又能涌泄，坚满自除。”

83.矾石生入腹，破人心肝，亦禁水。

【选注】

《金匱要略直解》：“矾石伤骨蚀肉，内用必伤心肝也。矾得水则化，故亦禁水。”

84.商陆以水服，杀人。

【选注】

《金匱要略直解》：“商陆有大毒，能行水而忌水服，物性相恶而然也。”

85.葶苈子傅头疮，药成入脑，杀人。

【选注】

《医宗金鉴》：“葶苈大寒，虽能傅疮杀虫，然药气善能下行，则疮毒亦内攻入脑矣，故杀人。”

86.水银入人耳，及六畜等，皆死，以金银着耳边，水银则吐。

【选注】

《医宗金鉴》：“水银大毒，入耳则沉经坠络，皆能死人，以金银着耳门，引之则吐出，此物性感召之理，犹磁石之引针也。”

87.苦练无子者，杀人。

【选注】

《金匱要略直解》：“苦练有雌雄两种，雄者无子，根赤有毒，服之使人吐不能止，时有至死者，雌者有子，根白微毒，可入药。（本宗奭）”

88.凡诸毒，多是假毒以投，无知时宜煮甘草荠苎汁饮之。通除诸毒药。

【选注】

《金匱要略直解》：“凡诸毒多借饮食以投毒，而服毒之人原自不知，若觉之则时时煮甘草荠苎汤饮之，以二物能解草石百毒也。”

《金匱要略论注》：“此总结前诸毒之伤人，谓一线之毒何能伤人，乃假些微毒气渗入元气，元气反为毒气作使，至不可疗。所谓星星之火势极燎原，亦惟以甘寒如甘草荠苎，培其本气为主，而兼与消解毒

气，自无不愈，故为通治诸毒之药。见诸解毒药不若此二味之精当，然亦可悟解毒之药概取甘凉矣。”

结语

本篇重点地论述了果实菜谷等食品的饮食卫生，以及预防和治疗上述食品中毒的方法和方药。指出瓜果、蔬菜、米谷等食物，如有不成熟的；被虫蚀过的；或日久而变质；或过饱食之，都能伤人正气而引起各种疾病。因此，健康者要注意饮食卫生，病者和孕妇更须注意，以防疾病因饮食影响而恶化，这样才能有利于健康长寿。本篇还指出春夏少食辛辣发散的食品，秋冬则少食生冷滑腻食品，若过饮之，均不利于身体健康。

本篇治疗食物中毒的方药，除涌吐毒邪外出，用豉、盐、苦参配苦酒外，主要是用甘草、荠苳、硬糖等甘寒之品以解毒邪。尤其是甘草配荠苳具有培扶正气，清解毒邪之功，故为通除诸毒之方药。

本篇与上篇是论述饮食卫生、预防和治疗各种食物中毒的专著。其中内容非常广泛，较完整地反映了古人在饮食卫生方面的思想和方法。特别是治疗食物中毒方法，如甘凉解毒之法，涌吐毒邪之法，冷服解毒药等治则和服药方法，是中医抢救食品中毒的精华部分，值得研究和探讨，以便更好地运用于临床实践之中，造福于广大人民群众。

附：《金匱要略方論》原文校勘

【《金匱要略方論》原文校勘說明】

《金匱要略詮解》是以《古今醫統正脈全書》（簡稱“醫統本”）為藍本。該書參考了明萬曆趙開美校刊《仲景全書》本（簡稱“趙刊本”）及涵芬樓藏明刊本（簡稱“明刊本”）校對，並作校勘後記。對於有疑問的條文、處方及方後注，則參考以下書籍進行對校。《金匱要略方論》醫統正脈本、《脈經》、《肘后备急方》（簡稱《肘后方》）、《諸病源候論》（簡稱《巢源》）、《備急千金要方》（簡稱《千金方》）、《千金翼方》（簡稱《千金翼》）、《外台秘要》（簡稱《外台》）、《注解傷寒論》、《三因極一病證方論》（簡稱《三因方》）、《金匱玉函經二注》（簡稱《二注》）、《金匱要略心典》（簡稱《心典》）、《醫宗金鑑》（簡稱《金鑑》）、《金匱玉函要略輯義》（簡稱《輯義》）、《金匱要略方論集注》（簡稱《集注》）、《金匱要略譯釋》（簡稱《譯釋》）。

【藍本及對校書目版本、出版年代】

《金匱要略方論》，人民衛生出版社，1972年。

《脈經》，人民衛生出版社，1962年。

《肘后备急方》，人民衛生出版社影印本。

《諸病源候論》，人民衛生出版社影印本。

《備急千金要方》，人民衛生出版社影印本。

《千金翼方》，人民衛生出版社影印本。

《外台秘要》，人民衛生出版社影印本。

《注解伤寒论》，人民卫生出版社，1978年。

《三因极一病证方论》，人民卫生出版社，1957年。

《金匱玉函经二注》，上海卫生出版社，1958年。

《金匱要略心典》，上海人民出版社，1975年。

《医宗金鉴》，人民卫生出版社，1979年。

《金匱玉函要略辑义》，人民卫生出版社，1956年。

《金匱要略方论集注》，人民卫生出版社，1957年。

《金匱要略译释》，江苏人民出版社，1958年。

【脏腑经络先后病脉证第一】

1.《二注》“心火气盛”下，又有“心火气盛”四个字。

《心典》认为“酸入肝以下十五句，疑非仲景原文，类后人谬添注脚，编书者误收之也”。

2.“禀”，《金鉴》作“秉”字。“贞”，《二注》作“真”。“才”作“纔”。“凡”，《金鉴》作“此”字。《二注》“复”作“覆”。

3.“腹中痛，苦冷者死”，《千金翼》作“腹中冷，苦痛者死”。“瘕”字在《二注》、《心典》、《金鉴》中皆作“瘕”，赵刊本作“瘕”，明刊本作“瘕”。

4.《千金翼》卷二十五“色脉”，后两个“语”字作“言”字。《心典》“语声寂然”作“语声寂寂然”，无自注“一作痛”三字。

《金鉴》按曰：“头中病之‘头’字，当是‘腹’字。经中从无头中病之文，且文义不属，必是传写之讹。”

5.《集注》“咳”作“欬”。咳与欬同用。《心典》“唾沫”作“吐沫”。

6.《金鉴》按曰：“吸促之促字，当是远字；吸远之远字，当是促字，方合病义，必传写之讹。”

7.“王时”和“王色”之“王”字，《心典》作“旺”。

9.《辑义》案曰：“扬雄《方言》：极，疲也。沈训急，未知何据。”

10.《辑义》案曰：“经云，今《内经》、《难经》无所考。”

《金鉴》：李彰曰：“厥阳即阳厥也。《内经》云：阳气衰于下则为寒厥，阴气衰于下则为热厥。”

11.《脉经》“平卒尸厥脉证第一”作：“寸口沉大而滑，沉则为实，滑则为气，实气相搏，血气入于藏即死，入于腑即愈，此为卒厥不知人。唇青身冷，为入脏即死，如身温和，汗自出，为入腑而复，自愈。”

《脉经》按此文有脱误。《千金方》云：“沉即为血实，滑即为气实，血气相搏，入藏即死”。接于“血气入于藏即死”句后。

《金鉴》按曰：“寸脉沉大而滑，沉则为实，滑则为气，实气相搏”之十八字，文理不顺，衍文也。血气入藏之“血”字，当是“厥”字，始与卒厥相合，必传写之讹也。

13.“**榮**飢”二字，《二注》、《金匱要略编注》作“**榮**飢”。《辑义》曰：“作‘**榮**飢’是。”徐作“**榮**飢”。《金匱要略方论集注》曰：“徐镕本作‘**榮**飢’。”全书徐、陈本作“**榮**飢”。今依尤本。《心典》作“穀飢”。

《金鉴》按曰：“字典无**榮**字，当是**榮**字。**榮**音倾，侧水也。后之积聚门，**榮**气之**榮**字，亦误。”

16.《译释》曰：“暴思之。”娄全善作“暴食之”。《心典》得上有“所”字。

17.《金鉴》按曰：“如渴者之下，当有小便不利四字，必传写之遗也。”

【痙湿喝病脉证第二】

1.《脉经》作“而反恶寒者”，反上有“而”字。《译释》曰：《玉函》、《千金翼》“反”上有“而”字。《甲乙经》无“反”字。古本“反”作“及”。

《金鉴》按曰：反恶寒之“反”字，衍文也。玩痙病之条自知当恶寒也。

2.《诸病源候论》“而不恶寒”作“而恶寒”，无“不”字。《脉经》

曰：“一云恶寒。”

3.《伤寒论》、《玉函》、《脉经》并无“为难治”三字。

4.《脉经》作“太阳病，发其汗因致瘧。论云发其汗太多，因致瘧。”

5.《脉经》作“复发其汗”，多“其”字。

6.《脉经》作“不可发其汗”，多“其”字。

7.《脉经》作“病者，身热足寒，颈项强急，恶寒，时头热，面赤，目脉赤，独头动摇者，为瘧。瘧病发其汗已，其脉澹澹如蛇，暴腹胀大者，为欲解。脉如故，反伏弦者，必瘧。”

《金鉴》按曰：“瘧病也之下，若发其汗……六句，与上文义不属，与后之……为欲解，脉如故，反伏弦者瘧句，文义相属，宜分于彼。”又按曰：“此条暴腹胀大者句，衍文也，当删之。”

《辑义》曰：一云，其脉澹澹。《伤寒论》作目脉赤，独头面摇。无“若发其汗”以下二十五字。瘧病也，作为瘧也。《玉函》、《脉经》无若发其汗以下十七字。《脉经》作瘧病发其汗已，其脉澹澹如蛇。相得，程、徐作“相搏”。澹澹，赵本作“沧沧”。沈本，脉上有其字。伏，《玉函》、《脉经》作“复”。

8.《脉经》“者瘧”二字之间有“必”字。自注曰：“一云瘧脉出欲已。”《金鉴》按曰：“本门首条瘧病也之下‘若发其汗’六句，当移于此条之首，文义始属。此条‘暴腹胀大者’句，衍文也，当删之。”

编者按：七、八两条的条文，从医统本。分段方法，从《脉经》，文义可通。

9.原注：“一作筑筑而弦。”《脉经》作“瘧家其脉伏坚直上下”。《脉经》、《甲乙》作“瘧脉来按之筑筑而弦，直上下行”。

10.《脉经》“难治”作“难疗”。

11.《脉经》、《玉函》无“反”字。

《三因方》瘧叙例治法，“沉迟”下有“自汗”二字，“桂枝”作“桂心”，“芍药”作“白芍药”，“甘草二两”后有“炙”字，生姜作“五片”，大枣“十二枚”作“二枚”。《心典》“微汗”上无“取”字。

12.赵刊本、明刊本、《伤寒论》作“呾咀”。“以水一斗”，《医统》本为“一斗”，赵刊本作“七升”，明刊本作“一升”。

《三因方》之葛根汤名“葛根麻黄汤”。

《伤寒论》作“桂枝”，当补“枝”字。《二注》芍药作“三两”。“生姜”，《伤寒论》中有“切”字。“大枣”，《伤寒论》中有“擘”字。

13.“病”字下[原注]一本“瘥”字上有“刚”字。

《脉经》作“刚瘥为病”，有“刚”字，“必”上有“其人”二字。《注解伤寒论》芒硝二合作“三合”，“火微一二沸”作“微火一两沸”，“止服”作“余勿服”。

14.[原注]脉沉而细一作缓。“湿痹”，《玉函》云“中湿”。

《脉经》作：“太阳病关节疼烦，脉沉而缓者，为中湿。”后有论云：“中湿为湿痹，湿痹之候，其人小便不利，大便反快，但当利其小便。”

《伤寒论》作“其人小便不利”，有“其人”二字。

15.《脉经》作“而身色似熏黄也”，多“而”字，改“如”字。《玉函》作“一身疼烦”。《伤寒论》作“身色如似熏黄”。

16.[原注]“小便不利”下有“一云利”三字。《脉经》“湿家”二字作“湿家之为病”，“背”上有“而”字，“早”作“蚤”，“不利”作“利”字，“胎”下无“者”字，“以丹田”作“此为丹田”，“渴欲”下无“得”字，“燥”下无“烦”字。《注解伤寒论》“啜”后无“或”字，“胸上”作“胸中”，“得饮”作“得水”。

17.《脉经》、《注解伤寒论》“小便利”下均有注云“一云不利”。

18.《脉经》“风”上有“问曰”二字，“一身尽”作“身体”，“医云”作“师云”，“汗之”作“而其”，“盖”作“答曰”，“气在”二字间有“续”字，“微微”上无“但”字，“则风湿俱去也”上多“则”字。《注解伤寒论》上有“问曰”二字；“何也”下有“答曰”二字，无“盖”字。

19.《脉经》无“湿家病”以下十个字，作“病人喘……”《注解伤寒论》“身疼”作“身上疼痛”。《千金翼》卷九条文与《脉经》同，“塞”作“窒”，“中和”二字间有“独”字。

20.《脉经》“加术汤”作“汤加术四两”。《辑义》按曰：“术分苍白，始出于名医别录，此白字后人所加，宜删。”《三因方》寒湿证治，方名为“麻黄白术汤”，条文作“治寒湿，身体烦疼，无汗，恶寒，发热者。”杏仁作“二十粒去皮尖”。

21.“所剧者”《脉经》作“即剧”。“名”作“此为”。无“可与麻黄杏仁薏苡甘草汤”十一字。《外台》麻黄作“四两”，甘草作“一两”，薏苡仁作“半升”，杏仁作“二两”。《辑义》按曰：“此方剂小，而煎法与诸方

异，盖后人所改定。”《外台》“脚气门”曰：“此本仲景方，分量小异。”

22.《脉经》“防己黄芪汤”作“防己汤”。《三因方》条文曰：“治伤风湿寒，脉浮紧细，身重，汗出，恶风。并治风水，脉浮身重不渴。”防己作“四两”，黄芪作“五两”，甘草作“二两”，白术作“三两”，“服后”二字之间有“药”字，“如冰”作“如水”。《心典》“钱七”作“钱匕”。

23.《脉经》“若大便坚”作“若其人大便鞭”，“去桂加白术汤”作“术附子汤”。《注解伤寒论》“去桂”二字下有“枝”字。

24.《注解伤寒论》“疼烦”作“烦疼”，附子“一枚”作“二枚”。

25.《脉经》“逆冷”作“厥冷”，“则其恶寒甚”作“恶寒则甚”，“热甚”二字之间有“益”字，“则淋甚”作“淋复甚”。《注解伤寒论》“发”下无“其”字，“则”下无“其”字。《辑义》“口开前”作“口前开”。

26.《脉经》“热”下无“者”字，“汗”上无“其人”二字，“渴”下有“也”字，无“加人参”三字。《注解伤寒论》“汗”上有“其人”二字，“渴”下有“也”字，无“白虎加人参汤主之”八字。

27.《脉经》“皮”下有“肤”字，无“一物”二字。《注解伤寒论》“喝”下有“者”字，“此以”作“此亦”，无“一物瓜蒂汤主之”七字。赵刊本，瓜蒂作“二十个”，明刊本，瓜蒂作“二七个”。

【百合狐惑阴阳毒病证治第三】

1.《脉经》原文作：“百合之为病，其状常默默，欲卧复不能卧，或如强健人，欲得出行而复不能行，意欲得食复不能食，或有美时，或有不用闻饮食臭时。如寒无寒，如热无热。朝至口苦，小便赤黄。身形如和，其脉微数。百脉一宗悉病，各随证治之”。《心典》“身形”上有“而”字，“渐”作“渐渐”，“或病二十日”作“或二十日”，“微见”作“后见”。

2.《千金》条文作：“治百合病已经发汗之后更发者，百合知母汤方。”“知母”后无“切”字。《二注》知母作“三钱切”。

3.《千金》作“治百合病已经下之后，更发者，百合滑石代赭汤方。”代赭用“一两”，无“如弹丸大一枚，碎，绵裹”九字。《心典》方

名亦作“百合滑石代赭汤”。

4.《千金》作“治百合病已经吐之后，更发者，百合鸡子汤方”。

5.《千金》“百合病”下有“始”字，“吐、下、发汗，病形”作“发汗、吐、下其病”。《外台》条文无“百合病”三字，“不经吐下发汗”作“不吐不下不发汗”，“初”下无“者”字，“地黄”上有“生”字，“大便常如漆”作“大便当出恶沫”。

6.《千金》“一”作“经”，“者”后有“方”字，无方名，“百合”下有“根”字，“宿”后文作“以汁先洗病人身也。洗身后食白汤饼，勿与盐豉也”。第七条在本条方后注中。

7.《千金》作“渴不差，可用栝楼根并牡蛎等分为散”，无“百合病”、“者”，无方名。

8.《千金》、《外台》“变”下有“而”字，“百合”下有“根”字。《千金》百合根下有“干之”二字。方后注中“除”字下有“一本云，治百合病，小便赤涩，脐下紧急”。

9.《脉经》两个“逆”字下，皆有“其病难治”四字。《千金》条文作“论曰，百合病见在于阴而攻其阳，则阴不得解也。复发其汗，为逆也。见在于阳而攻其阴，则阳不得解也。复下之，其病不愈”。

10.《脉经》“惑”下无“之”字，“状”作“其气”，“狐不”二字之间多“狐惑之病，并”五字，“闻”上无“恶”字，“乍黑、乍白”作“乍白、乍黑”，“白”字下作“其毒蚀于上者则声喝，其毒蚀于下部者则咽干。蚀于上部，泻心汤主之”。明刊本，半夏半斤。《千金》卷十“之为病”作“之病”，“状”作“其气”，“默默”作“嘿嘿”，“卧起”作“起卧”，“乍”字作“翕”，“安”字后条文作“其毒在咽喉为惑病，在阴肛者为狐病。狐惑之病，并恶食饮，不欲食，闻食臭其面目翕赤、翕白、翕黑。毒食于上者，则声喝也。毒食下部者，则干咽也。此由温毒气所为。食于上者，泻心汤主之。”《外台》作“嘿嘿但欲卧，目瞑不得眠，起卧不安”，“喝”作“嗝”，作“泻心汤主之”，无“甘草”二字。

11.《脉经》作“蚀于下部，苦参汤淹洗之”。《千金》“蚀”作“食”。《心典》“日三”后无“服”字。

12.《脉经》“蚀”作“食”。《千金》条文作“食于肛外者熏之，并用雄黄三片，稍置瓦**铤**中，炭火烧，向肛熏之，并服汤也”。

13.《脉经》“病者”作“其人”，“默”下无“但”字，“得”下无“之”字，“七八”上有“得之”二字，“黑”上有“黄”字。《千金》“目

赤”作“眼赤”，“黑”上有“黄”字，“能”上无“若”字。《千金》“以赤小豆三升渍之，令生芽足，乃复干之，加当归三两为末。浆水服方寸匕，日三即愈”。原本当归缺两数，可补之。《心典》当归作“十两”。

14、15.《脉经》条文作“阳毒为病，身重腰背痛，烦闷不安，狂言，或走或见鬼，或吐血下痢，其脉浮大数。面赤斑斑如锦文，咽喉痛，唾脓血。五日可治，至七日不可治也。有伤寒一二日，便成阳毒，或服药，吐下后变成阳毒，升麻汤主之”。“阴毒为病，身重背强，腹中绞痛，咽喉不利。毒气攻心，心下坚强，短气不得息，呕逆，唇青面黑，四肢厥冷，其脉沉细紧数。身如被打，五六日可治，至七日不可治也。或伤寒初病一二日，便结成阴毒。或服药六七日以上至十日，变成阴毒，甘草汤主之。”

【疟病脉证并治第四】

1.《脉经》“师曰”作“夫”，“下之差”作“可下之”，“可温之”作“可温药”，“弦紧者，可发汗针灸也”作“若脉紧数者，可发汗针灸之”，“弦数”上有“脉”字。《金鉴》按曰：“弦小紧者之‘小’字，当是‘沉’字，则有可下之理。弦紧者，当是‘弦浮紧’，则有可发汗之理。弦浮大者，当是‘弦滑大’，则有可吐之理。且不遗本文疟脉自弦之意。”

2.《脉经》条文作“疟病结为癥瘕，名曰疟母，鳖甲煎丸主之”。《千金》“如其不差”作“今不愈”，“急治”二字之间有“当”字，鳖甲作“成死鳖”，桂枝作“桂心”，无赤硝，有大戟、虻虫。“虻虫各三十铢，《要略》作鼠妇。”“海藻，《要略》作赤硝”。方后注曰“右二十四味，末之”。《千金》分两颇异，不繁引于此。干姜，明刊本作“二分”。

3.《千金》“师曰”作“有瘧疟者”，“发”下有“而脉微”三字，“则热而”作“其候必”，“冤”作“满”。《金鉴》按曰：“此言瘧疟，其文脱简，《内经》已详，不复释。”《辑义》按曰：“《素问·疟论》曰：但热而不寒，气内藏于心，而外舍于分肉之间，令人消烁脱肉。”“则”赵本为“是”。“肌”赵本作“脱”。

4.《脉经》条文冠以“疟，但见热者”五字，“者”作“也”，无“如”字，“呕”字下有“朝发暮解，暮发朝解，名曰温疟”十二字。《注解伤寒论》粳米二合应作“六合”。桂，《二注》作“桂枝”。《千金》方后注曰：“右四味^咬咀，以水一斗二升煮米烂，去滓，加桂心三两，煎取三升，分三服，覆令汗，先寒，发热汗出者愈。”《心典》方后注

曰：“右五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三。”

5.《金鉴》“牡”作“牝”。《脉经》“名曰牡疟”作“牡疟也”。《千金》“疟多”无“疟”字，“杵为散”作“等分治下筛”，“发”下有“一炊顷”三字，“浆”上有“酢”字，“钱”下又有“临发服一钱”。

牡蛎汤：《金鉴》、宋本、程本都不载附方，以下各篇同。蜀漆，《千金》云：“无以恒山代之。”《外台》云：“若无，用常山代之。”又《千金》、《外台》“右四味下”有“先洗蜀漆三遍去腥”八字。

柴胡去半夏加栝蒌汤：《金匱要略方论集注》曰：“《外台》引张仲景《伤寒论》疟发渴者，与小柴胡去半夏加栝蒌汤。”《经心录》疗劳疟，出第十五卷中。

柴胡桂姜汤：《译释》按曰：“《伤寒论》作柴胡桂枝干姜汤，方在太阳下篇。”《三因方》作治牝疟。

《辑义》按曰：“此方《外台》疟门无所考，本出于《伤寒》太阳中篇。”

【中风历节病脉证并治第五】

1.《辑义》按曰：“脉微而数可疑，今验风病，多脉浮大而滑，而或数或不数。”

2.《脉经》作“口吐瘀涎”。《二注》作“口吐涎沫”。

《金鉴》按曰：“寸口脉浮而紧，紧则为寒，浮则为虚，寒虚相搏，邪在皮肤。”此五句与本条文义不属，当在后条之首。后条“寸口脉迟而缓，迟则为寒，缓则为虚；荣缓则为亡血，卫缓则为中风；邪气中经。”此六句亦与本条文义不属，当在此条之首，文气相属。必是错简。其中有“浮者血虚”一句，必是衍文。浮则为虚，寒虚相搏，二“虚”字当是“风”字，是传写之讹。

侯氏黑散 [原注]《外台》治风癫。

《辑义》曰：“‘六十日止，即药积’七字，赵本作‘自能助药力’五字，非。”

《辑义》：“食”下“自”字，《辑义》作“曰”字。

《二注》：冷食能助药力，无“自”或“曰”字。

《译释》按曰：侯氏黑散，很多注家均疑为宋人所附，据丹波元简云：“此方主疗文法，与前后诸条异，先揭方名而后治云云者，全似后世经方之例，故程氏、尤氏、《金鉴》并云宋人所附。然《巢源》寒食散发候云，仲景经有侯氏黑散，《外台》风癰门载本方引古今录验，无桔梗有钟乳、矾石……乃知此方隋唐之人以为仲景方，则非宋人所附较然矣。”

3. 《脉经》作“身痒而癰^疹”。

《辑义》曰：“‘中经’，沈本作‘入经’。”

《金鉴》按曰：“寸口脉迟而缓，迟则为寒，二‘迟’字当是‘浮’字，‘寒’字当是‘风’字，始得文义了然。且迟缓二脉不能并见，必是传写之讹。”

风引汤“日数十发”，赵刊本、明刊本作“日数十后”。

《辑义》按曰：“此方亦非宋人所附，《外台》风癰门引崔氏甚详，云：疗大人风引，少小惊癰瘰疬，日数十发，医所不能疗。除热镇心，紫石汤，方与本方同，右十二味，捣筛，盛以韦囊，置于高凉处，大人欲服，乃取水二升，先煮两沸，便内药方寸匕，又煮取一升二合，滤去滓，顿服之，少未满百日，服一合，热多者，日二三服，每以意消息之。永嘉二年，大人小儿，频行风癰之病，得发例不能言，或发热，半身掣缩，或五六日，或七八日死。张思惟合此散，所疗皆愈。此本仲景《伤寒论》方。《古今录验》，范汪同。《千金》风癰门，紫石散即本方，主疗服法并同。由此观之，风引即风癰掣引之谓。而为仲景之方甚明，程氏、尤氏辈亦何不考也，但除热癰癰四字，义未充。刘氏《幼幼新书》，作除热去癰癰。癰，楼氏《纲目》作除热癰癰，王氏《准绳》同，其改癰作癰，于理为得矣。”

《辑义》又按曰：“《巢源》‘脚经候’云：脉微而弱，宜服风引汤。”

防己地黄汤《千金方》第十四卷“风眩门”云：“治语狂错，眼目霍霍，或言见鬼，精神昏乱。防己、甘草各二两，桂心、防风各三两，生地黄五斤别切，勿合药渍，疾小轻用二斤，右五味，^咬咀，以水一升，渍之一宿，绞汁，著一面取其滓著竹箬上，以地黄著药滓上，于三斗米下蒸之，以铜器承取汁，饭熟以向前药汁合绞取之，分再服。”

头风摩散方《千金方》方名作头风散方。大附子一枚中形者，盐如附子大。无“已”字，“痰”作“顶”。

赵刊本、明刊本，“已摩痰上”作“已摩疾上”。

4.《脉经》沉“则”、弱“则”之“则”字在医统本皆作“即”字。

历节黄汗出，“历节”下《金匱要略方论集注》有“痛”字。

6.《金匱要略方论集注》曰：“古本少阴病，脉浮而弱，弱则血不足，浮则为风，风血相搏则疼痛如掣，宜桂枝汤加当归主之。即桂枝汤加当归二两。”

8.《脉经》“尪羸”作“魁瘰”。

《医宗金鉴》按曰：“温温”当是“嗢嗢”。

9.《医宗金鉴》按曰：名曰断泄之“泄”字，当是“绝”字，始与下文相属，必是传写之讹。

10.《脉经》作“疼痛不可屈伸”。

《金鉴》删去“治脚气疼痛，不可屈伸”。

矾石汤《金鉴》不载此方，至篇末五方并删。《千金翼方》“浸”下有“洗”字。

《古今录验》续命汤《外台秘要》“浮肿”作“洪肿”。《心典》“收”下有“持”字。

《千金》三黄汤《备急千金要方》与《千金翼方》名曰“仲景三黄汤”，“拘急”作“拘挛”。《三因极一病证方论》曰：“兼治贼风，偏风，猥退风，半身不遂，失音不语。麻黄去节汤一两一分、黄芪半两、黄芩三分、独活一两。”

《近效》术附汤《外台秘要》卷十五“风头眩”曰：“《近效》白术附子汤：白术三两、附子二枚炮、甘草二两炙、桂心四两。此本仲景《伤寒论》方。”《外台秘要》按语，尚德按曰：“《伤寒论》名甘草附子汤。”

崔氏八味丸《外台秘要》卷十八曰：“又若脚气上入少腹，少腹不仁，即服张仲景八味丸方：干地黄八两、泽泻四两、附子二两炮，薯蓣四两、茯苓三两、桂心三两、牡丹三两去心、山茱萸五两，右八味捣筛，蜜和为丸如梧子，酒服二十丸。”

编者按：外台有脚气不随方五首，其中第四首即张仲景八味丸。可见是崔氏收录仲景之方。《旧唐书·经籍志》有《崔氏纂要方》十卷，为崔知悌撰。《新唐书·艺文志》为崔行功撰。

《千金》越婢加术汤《备急千金要方》卷七“风毒脚气门”中载有：“越婢汤治风痹脚弱方。麻黄六两、石膏半升、白术四两、大附子

一枚、生姜三两，甘草二两、大枣十五枚。”

《外台》亦有附子。

【血痹虚劳病脉证并治第六】

1.赵刊本、明刊本，“因”作“困”。《脉经》“血痹”下无“病”字。“遂得之”下有“形如风状”。

2.《脉经》“如风痹状”作“如风状”。《千金方》同。“黄芪桂枝五物汤”，《千金方》名“黄芪汤”，方中有人参。蜀黄芪、人参、芍药、桂心各二两。

3.《心典》作“脉极虚亦为劳”，多“脉”字。

4.《金鉴》按曰：“脉浮者，里虚也”句，当是衍文。

5.《脉经》作“时时目瞑，此人喜衄。”

6.《脉经》作“男子劳之为病”，有“男子”二字；“足酸削不能行”，有“足”字；“行”下有“少阴虚满”四字。《金鉴》：“‘阴寒精自出’之‘寒’字，应是‘虚’字，当改之。”

7.《脉经》“浮”作“微”。《辑义》按曰：[原注]一作泠。泠，水名，作泠为是。

8.《脉经》“脉得诸朮动微紧”另作一条，“桂枝”下有“加”字，“目眩”作“目眶痛”。

《医宗金鉴》按曰：此条“脉得诸朮……”五句，与上文义不属，衍文也。另分一条……

天雄散方《外台秘要》卷十六，载范汪疗男子虚失精，三物天雄散方。天雄三两炮、白朮八分、桂心六分。右药捣下筛，服半钱匕，日三，稍稍增之，忌猪肉冷水桃李雀肉生葱。张仲景方有龙骨，文仲同。出第六十八卷中。

9.《脉经》作“喜盗汗出也”。

赵刊本、明刊本作“善盗汗也”。

10.《脉经》“若肠鸣”作“苦肠鸣”。

《金鉴》按曰：“‘若肠鸣’三字，与上下文不属，必是错简，当删之。侠瘕之‘瘕’字，当是‘瘰’字，且先劳后瘰，先瘰后劳者有之，从未见劳瘕先后病也，当改之。”

11.《辑义》按曰：“沈云‘喝’当作‘急’，非也。灵枢经脉篇，喝喝而喘。”

12.《金鉴》按曰：“此条注详见《伤寒论·辨脉篇》内，故不复释。”

13.《外台》卷十七“虚劳心腹痛”曰：“《古今录验》疗虚劳，腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥，并妇人少腹痛，芍药汤方。”方中桂枝作桂心，生姜三两作四两，胶饴一升作饴糖一斤。方后注曰：“此仲景小建中汤方。”

赵刊本、明刊本生姜作“二两”。《伤寒论》生姜作“三两”。

14.《外台》黄芪作“三两”，芍药作“二两”，生姜作“四两”，饴糖作“一斤”。方后注云：“呕者倍生姜，腹满者去枣，加茯苓四两。忌生葱、海藻、菰菜。此本仲景方，恐是甘草二两，芍药六两，生姜三两也。”

15.《千金方》曰：“八味肾气丸，治虚劳不足，大渴欲饮水，腰痛，小腹拘急，小便不利方。”《千金》注曰：“仲景云：常服去附子加五味子。”

16.《千金方》卷十九“肾脏门”曰：大署预丸，主男子女人虚损伤绝，头目眩，骨节烦痛，饮食微少，羸瘦百病方。共二十四味，有泽泻、附子、黄芩、天门冬、石膏、前胡、干漆、五味子、大黄，无麴、芍药、麦门冬、柴胡、茯苓、防风等药。

17.《三因极一病证方论》曰：酸枣仁汤治霍乱，吐下增剧，虚劳烦扰，奔气在胸中，不得眠，或发寒热，头疼，晕闷。有人参、桂心、石膏，无芍药。共七味。

18.《心典》：荣作营。干漆一两下有“烧令烟尽”四字。虻虫一升下有“去翅足熬”四字。水蛭百枚下有“熬”字。蛭螬作百枚，下有“熬”字。廌虫半升，下有“熬”。酒饮服，无“饮”字。

《千金翼》炙甘草汤《千金翼方》卷十五补益有“复脉汤主虚劳不足，汗出而闷，脉结心悸，行动如常，不出百日，危急者二十一日死方。”

《肘后》獭肝散《肘后备急方》治尸注鬼注方，曰獭肝一具，阴干捣末，水服方寸匕，日三，一具未差更作，姚云神良。

【肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治第七】

1. 《脉经》“又被快药”作“数被驶药”，“曰：寸口脉数”上有“问”字，“向”下有“也”字，“为肺痿之病”上有“此”字，“咳即胸中”作“欬则胸中”，“数实者”上有“脉”字。

2. 《脉经》“吐之则死”下有“后竟吐脓死”五字。《脉经》、《千金》“血为”下无“之”字。《脉经》“揉”作“救”。赵刊本、明刊本“多唾浊沫”作“时唾浊沫”。

3. 《辑义》按曰：“上气，诸家不释，考《周礼天官》疾医职云：嗽上气。”

4. 《脉经》、《千金》“喘而躁者”作“躁而喘者”。

5. 《脉经》“以温之”作“温其藏”，无“若以下”九字。《千金》卷十七肺痿第六“若”下九字作“服汤已，小温覆之，若渴者，属消渴法”。

6. 《外台》“喉中水鸡声”作“咽中如水鸡声”，射干“十三枚”作“十二枚”，“麻黄”下有“去节”二字，“半夏”下无“大者”二字，方后注“以”字下有“东流”二字，“三服”下有“忌羊肉，饴生菜”六字。

7. 《心典》“唾浊”作“吐浊”。

8、9. 《心典》“脉沉者”上有“咳而”二字。《辑义》将“脉浮者”与“脉沉者”二条并作一条。

10. 《二注》、《心典》：“大逆上气”俱作“火逆上气”。《心典》无“者”字。

《金鉴》按曰：“大逆上气之大字，当是火字，文义病药始相属，当改之。”

11. 《千金》卷十七，“葶苈”下无“熬令”等十字，有“三两末之”四字，大枣“十二枚”作“二十枚”。

12. 《千金》卷十七，“咳而胸满”作“治咳胸中满”，“咽干”下有“而”字，“时”作“时时”，“如米粥者”作“如粳米粥是”，桔梗“一两”作“三两”，《集验》用“二两”，《古今录验》用“一枚”。

13. 《外台》“咳而上气，此为肺胀，其人喘”作“又肺胀者病人喘”，“浮大者”作“浮大也”。

14. 《千金》作“咳而上气肺胀，其脉浮，心下有水气，胁下痛引缺

盆，设若有实者必躁，其人常倚伏。”

《外台》炙甘草汤《外台》卷十曰：“仲景《伤寒论》疗肺痿”，有甘草干姜汤、炙甘草汤二方。

《千金》甘草汤《千金》卷十七肺痿第六曰：“治肺痿涎唾多出血，心中温温液液，甘草汤方。”《千金翼》名“温液汤”。

《千金》生姜甘草汤《千金》卷十七，大枣作“十二枚”，“味”字下有“咬咀”二字，“三升”下有“去滓”二字，“分温三服”无“温”。

《千金》桂枝去芍药加皂荚汤《千金》“沫”下有“不止”二字，大枣作“十二枚”，“味”下有“咬咀”二字，“三升”下有“去滓”二字，“分”下无“温”字。

《外台》桔梗白散《外台》卷十“肺痈门”曰：“仲景《伤寒论》，咳胸中满而振寒……”“如米粥”作“如粳米粥”，“则定”下有“忌猪肉芦笋等”六字。

《千金》苇茎汤《千金》卷十七肺痈第七，“胸中”作“胸心”，桃仁“五十枚”作“三十枚”，“服一升”后作“当有所见吐脓血”。

15.《千金》卷十七，“胸满胀”作“胸胁胀”，“香臭”下无“酸辛”二字，“主之”后又有“用前方先服小青龙汤一剂，乃进之小青龙汤方”。

【奔豚气病脉证治第八】

2.《脉经》“奔豚病”下有“者”字，“少”作“小”，“发作”下有“时”字，“复”下无“还”字，“惊恐得之”作“惊得”。

3.《脉经》“奔豚气”作“其气”，“往来”上有“及”字。

4.《注解伤寒论》无“发汗后”三字，“上至心”作“上冲心者”，“主之”作“更加桂二两”。

5.《注解伤寒论》卷三，“后”下有“其人”二字，茯苓、甘草、大枣量后有“味甘平”三字，大枣有“擘”字，桂枝有“去皮”二字，“甘澜水”上有“作”字，“甘澜水”后三十字皆作方后注正文。

【胸痹心痛短气病脉证治第九】

1.《脉经》“过不”二字之间有“与”字，“即”作“则”，“以其”下有“脉”字。《外台》卷十二胸痹短气门，“师曰”作“《千金》论曰”，“虚也”二字之间有“故”字，“以其”下有“脉”字。

3.《脉经》“紧数”下有“者”字，《外台》同。《外台》“寸口”作“其”字。方名作“栝楼汤”。《外台》方后注曰：“仲景《伤寒论》无生姜、枳实、半夏等三味。”

4.《外台》卷十二胸痹心痛方，方名作“栝楼薤白半夏白截浆汤”，“日三”下无“服”字。

5.《外台》卷十二，“胸痹”上有“范汪疗”三字，“痞气”作“痞坚”，“气结在胸”作“留气结于胸中”，“逆”作“逆气”，方名作“枳实汤”，“桂枝”作“桂心”，“三服”后有“除心气良”四字，文中无“人参汤亦主之”六字。

6.《千金》卷十三心脏门，曰“胸痹之候，胸中怫怫如满，噎塞习习如痒，喉中涩燥唾沫，宜此方：橘皮一斤、枳实四枚、生姜半斤。”又曰“治胸中气塞，短气，茯苓汤方”。茯苓汤方之药味与用量与茯苓杏仁甘草汤同。

7.《外台》卷十二，“胸痹”下有“偏”字，薏苡人“十五两”作“一千五百枚”，方名作“薏苡人散”。

8.《外台》卷七心下悬急懊痛方，曰：“仲景《伤寒论》：心下悬痛，诸逆大虚者，桂心生姜枳实汤主之方。”方同。

9.《外台》卷七心背彻痛方，文同。乌头作“二分，炮去皮”，附子作“一分，炮去皮”，赤石脂作“二分”，干姜作“二分”，蜀椒作“一分，汗”。

附方：九痛丸《千金》卷十三心脏曰：“九痛丸，治九种心痛，一虫心痛，二注心痛，三风心痛，四悸心痛，五食心痛，六饮心痛，七冷心痛，八热心痛，九去来心痛，此方悉主之，并疗冷冲上气，落马堕车血疾等方。”附子、干姜作“二两”，“生狼牙一两炙香”作“生狼毒四两”，无“炙香”二字。

【腹满寒疝宿食病脉证治第十】

1.《脉经》“必”字下有“下部闭塞大”五字。

2.《玉函》“病者”作“伤寒”，“去”下有“宜大承汤”。

3.《脉经》“减”下更有“减”字。《金鉴》按曰：此篇无治虚寒腹满之方。当与温药之下，当有“宜厚朴生姜甘草半夏人参汤主之”十四字，必是脱简。阅《伤寒论·太阳篇》自知，当补之。

4.《脉经》将此条列于《平呕吐哕下利篇》末，“胸中”作“胃中”，“利”上有“下”字。

《金鉴》按曰：“躁而不渴”当是“燥而不渴”，文气通顺。“胸中寒实”当是“胃中寒实”，若是胸中寒实，如何曰下利不止者死，当改之。

5.《脉经》“即”作“则”。

6.《千金》卷十六胃腑曰：“论曰，凡人中寒者，喜欠。”下同。

7.《千金》卷十六胃腑曰：“此人中寒”，多“此人”二字。“此人肚中寒”作“此人腹中痛”。

8.《千金》卷十六，“夫瘦人”作“凡瘦人”。

9.《千金》卷十六胀满第七曰：“厚朴七物汤，治腹满气胀方。仲景云：治腹满发热数十日，脉浮数，饮食如故者。”

10.《千金》卷十六，“雷鸣切痛”作“胀满肠鸣切痛”，附子无“炮”字。《外台》卷七，“气”下有“胀”字，“满”下无“呕吐”二字。

11.《脉经》卷八曰：“病腹满，发热数十日，脉浮而数，饮食如故，厚朴三物汤主之。”《千金》卷十六，本条条文同《脉经》。

12.《金鉴》按曰：“按之心下满痛”之下，当有“有潮热”三字，若无此三字，则不当与大柴胡汤，当补之。

13.《脉经》无“须”字，无“宜大承气汤”五字。

14.《千金》卷十六，“寒痛”间有“大”字，“食”下有“饮食下咽自知偏从一面，下流有声泱泱然，若”十八字，“腹中寒”下有“气”字，“上下痛而”作“上下而痛其头”，“心胸中”作“心胁中”。

15.《脉经》“偏痛”下无“发热”二字。《千金》“以温药”作“当以温药”。

16.《千金》卷十六，赤丸方作“茯苓、桂心各四两，细辛一两，乌头、附子各二两，射罔加大枣一枚”。

17.《脉经》作“寸口脉弦而紧，弦则卫气不行，卫气不行，则恶寒，紧则不欲食，弦紧相搏，则为寒疝”。为一条。第二条为“趺阳脉浮而迟，浮则为风虚，迟则为寒疝，寒疝绕脐痛，若发则自汗出，手足厥

寒，其脉沉弦者，大乌头汤主之”。《千金》“脐”下有“苦”字，“发”上无“若”字，“则”作“即”，“津”作“汗”，“厥冷”作“厥寒”，“沉紧”作“沉弦”，“煎”作“汤”。

18.《外台》卷七，“及胁痛里急者”作“引胁痛及腹里急者”，“羊肉一斤”作“肥羊肉一斤去脂”。

19.《千金》卷十六，“寒疝”上有“大”字，“若”下有“一”字，“身”下有“尽”字，无“疼”字，无“抵当”二字，乌头作“秋干乌头，实中者五枚除去角，白蜜一斤。”

20.《脉经》卷八，“其脉数”作“夫脉浮”，“脉紧大”作“脉双弦”，“有阴”下有“也”字。

附方

《外台》乌头汤《千金》卷八贼风门，“入”下有“腹”字，“发作”上有“叫呼”二字。乌头十五枚，《要略》用五枚。芍药四两、甘草二两、大枣十枚、老姜一斤、桂心六两。

《外台》柴胡桂枝汤《外台》卷七云：“又疗寒疝腹中痛者。”有“寒疝”二字，无“心”与“卒”二字。方后注中又曰：“人参汤作如桂枝法，加半夏、柴胡、黄芩，复如柴胡汤法，今著人参作半剂，忌海藻、菰菜、羊肉、饴、生葱。”

《外台》走马汤 见《外台》卷七卒疝方。王焘云：“又若不差，服诸利丸下之，走马汤亦佳，此名寒疝，亦名阴疝。张仲景飞尸走马汤方。”

21.《金鉴》按曰：“尺中亦微而涩”之“微”字，当按《伤寒论》作“大”字是。

22.《脉经》作“脉滑而数者实也，有宿食，当下之。”《千金》作“下利，脉滑而数，有宿食，当下之”，皆无“宜大承气汤”五字。

23.《脉经》、《千金》皆无“也”字，无“宜大承气汤”五字。

24.《脉经》“脘”作“管”，无“宜瓜蒂散”四字。

25.《脉经》卷八，“脉”上有“寸口”二字，“无”字上有“左右”二字，“食”下无“也”字。

26.《脉经》“脉”上有“寸口”二字，“头”上有“即”字，“腹”上

有“或”字，“化”下无“也”字。

【五脏风寒积聚病脉证并治第十一】

1. 《金鉴》按曰：“身运而重”当是“头运而身重”，“冒而肿胀”当是“冒风而肿胀”，乃与文义始为相属，当改之补之。《辑义》肿作“腹”。

2. 《千金》卷十七肺脏，“寒”下有“者”字，“吐”上有“其人”二字。

3. 《千金》肺藏脉论条文相同。

4. 《千金》卷十一肝脏门肝脏脉论，“甘”下有“如阻妇状”四字。

5. 《千金》卷十一，“两”上有“其人”二字，“本”下自注有“又作大”三字，“喜”作“善”，“食则吐而汗出也”作“时盗汗咳，食已吐其汁”。

《金鉴》按曰：“两臂不举，舌本燥”二句，“而汗出”三字，文义不属，必是错简，不可为后世法。不释。

6. 《千金》“之”下有“中”字。

7. 《千金》“其”下有“病”字。无“旋覆花汤主之。”

8. 《千金》卷十三心脏，“食即呕吐”作“而欲食，食则呕”。

9. 《千金》“人”下无“苦”字，“蒜”下有“藟”字，“如”上无“譬”字。

10. 《千金》“伤”下无“者”字，“倦”下无“即”字，“而自烦”作“彻背自烦”，“跳”下有“手”字。

11. 《千金》“丸豆”作“豆麻击手”。

12. 《千金》“则畏”作“即畏”，“为癲”和“为狂”之上皆有“即”字。

《金鉴》按曰：“‘阴气衰者为癲’之‘癲’字，当是‘狂’字；‘阳气衰者为狂’之‘狂’字，当是‘癲’字。《内经》曰：重阴者癲，重阳者狂。当改之。”

13. 《千金》卷十五上，“目”作“肉”，“气”下有“也”字。

14. 《千金》“大坚”作“大缓”。

15. 《千金》“约”下有“脾约者，其人大便坚，小便利，而反不渴”十五字。

16. 《千金》卷十九，本条文出现在“肾脏脉论第一”和“腰痛第

七”中，今以后者为准校之。“之病”二字之间有“为”字，“如坐水中，形如水状”作“腰中冷如水洗状”，无“反”字，“饮食”作“食饮”，“病属下焦”作“是其证也”，“身”作“从”，“甘姜苓术汤”作“肾著汤”，白术作“四两”，干姜作“三两”，“腹重”一作“腰重”、 一作“腹重”。

17.《千金》“益”仍作“益”，非作“益”也。

18.《注解伤寒论》平脉法第二，无“三焦竭部”四字，无“何谓也”三字，无“师曰”二字，“气未”之间有“中焦”二字，无“其气不和”以下十五字。成无己本下有一段长文。

19.《脉经》卷八，“师曰”作“问曰”。《千金》卷十八大肠腑，“大肠有寒者”无“者”字，无“多”字，“有热者”无“者”字。《千金》卷十四小肠腑无“者”字。“便”下有“脓”字。

20.《脉经》平五脏积聚脉证，“**榮**”作“**繫**”，自注曰：“**繫**一作穀”。“复发”上有“愈”字，“**榮**气”下有“夫病已愈不得复发，今病复发，即为**繫**气也”，“尺”下无“中”字，“冲”作“街”，“脉出左”之“左”上有“在”字，“脉出右”之“右”上有“在”字。

【痰饮咳嗽病脉证并治第十二】

1.《脉经》“痰饮”作“淡饮”。

2.《脉经》“气短”作“短气”。《巢源》卷二十，“沥沥有声”作“漉漉有声”。

3.《千金》卷十八痰饮第六，“在心”二字之间有“于”字，二心之间有“其人”二字，“筑”下更有一“筑”字，“恶水”下有“而”字。

4.《千金》“在肺”二字之间有“于”字，“吐”上有“其人”二字。

5.《千金》卷十八，“在脾”二字之间有“于”字，“少”上有“其人”二字，“身重”作“身体尽重”。

6.《千金》卷十八，“在肝”二字之间有“于”字。

7.《千金》“在肾”二字之间有“于”字。

8.《脉经》卷八，“冷如水大”作“冷大如手”。《二注》作“冷如掌大”。《心典》、《金鉴》皆作“冷如掌大”。

- 9.《脉经》“则辄已”作“转甚”。
- 10.《脉经》“脉沉”上有“其”字。
- 11.《脉经》“膈上病痰，满喘咳吐”作“膈上有病，满喘咳吐”，自注“目泣自出，一作目眩”。《千金》作“膈上之病”，“背痛”作“恶寒”。
- 12.《脉经》“水停心下”作“心下水停”。《千金》卷十八，“人”下有“卒”字，“喜虚”下有“耳”字。
- 13.《脉经》、《千金》“苦”作“喜”。
- 14.《千金》“卧”作“眠”。
- 16.《脉经》“苓桂术甘汤”作“甘草汤”，自注“草一作遂”。
- 18.《脉经》卷八，“利”下有“者”字。《千金》芍药“五枚”作“三枚”，芍药、甘草下有“水一升，煮取半升”，方后注“右四味，以蜜半升，内二药汁，合得一升半，煎取八合，顿服之”。
- 22.《千金》“明日”作“明旦”。“糜粥自养”作“下后自补养”。赵刊本、明刊本作“九合”。《千金》、《伤寒论》作“八合”。
- 23.《脉经》无“大青龙汤主之”、“亦”七字。
- 24.《脉经》“木防己汤主之”之下无“虚者即愈”等三十一字。《千金》卷十八，“间”下有“有”字，“面”下无“色”字，“虚者即愈”等三十一字放入方后注中，“发”后有“发则”二字，无“者”字。
- 25.《外台》“苦冒”二字作“喜”，“分温再服”作“分为再服”，“分为”上有“又以水一升，煮取五合，合此二汁”十三字，“再服”下有“忌桃李雀肉等”。
- 26.《千金》卷十八，《外台》卷八，“支饮胸满”上有“夫酒客咳者，必致吐血，此坐久饮过度所致也，其脉虚者必冒，其人本有支饮在胸中也”，“满”下无“者”字。《千金》枳实作“四两”。《外台》厚朴作“一两，炙”，枳实作“四两，炙”。
- 28.《千金》条文作“呕家不渴，渴者为欲解，本渴，今反不渴，心下有支饮故也，小半夏汤主之”。《脉经》条文与《医统正脉》本相同。
- 29.《脉经》“舌”作“苦”，“气”下有“也”字，“己椒蒴黄丸”作“防己椒目葶蒴大黄丸”。《千金》无“舌”字，方名为“椒目丸”，葶蒴下有“熬”字、作“二两”，方后注中“日三”下无“服”字，“津液”下有“止”字。

30.《千金》“眩悸”上有“目”字，下无“者”字。方后注中，“味”下有“咬咀”二字，“合”下有“去滓”二字。

31.《脉经》“悸”上无“有”字，“眩”下有“者”字，“水”上无“此”字。《千金》“悸”下有“者”字，“水”上无“此”字。《外台》泽泻作“五分”。

附方

《外台》茯苓饮《外台》卷八中，“茯苓饮”上有“延年”二字并冠条文之首，“出水”作“水出”，人参用“二两”，橘皮用“二两半”，“进之”下有“忌酢物桃李雀肉等”。

32.《千金》“其”下有“人”字，“十”上有“可与”二字，“主之”作“下之”，“汤下之”后有“方见下，不能卧出者，阴不受邪故也”十四字。

33.《千金》卷十八，“一岁”上无“或”字，“宜”作“可与”二字。

34.《脉经》“死”作“不可治”。

35.《千金》“桂枝”作“桂心”，方后注有“弱者服半升。若渴，去半夏加栝楼根三两；若微痢，去麻黄加薤花如鸡子大；若食饮噎者，去麻黄加附子一枚；若小便不利，小腹满者，去麻黄加茯苓四两；若喘者，去麻黄加杏仁半升。”

36.《千金》“厥逆”作“厥冷”，“桂枝”作“桂心”、用“三两”。赵刊本、明刊本作“分三温服”。

37.《千金》方名作“茯苓甘草五味子，去桂加干姜细辛”。

38.《千金》“支饮者”下无“者”字，“其水”后有“方”字，无方名。

39.《千金》“肿者”后作“应内麻黄，以其人遂痹，故不内麻黄，内杏仁方”，“若逆而内之者，必厥”以下之文在方后注中，“之”作“麻黄”，“必厥”上有“其人”二字。

40.《千金》“其面”作“耳面”，无“以”字，“之”后有“方”字，无方名。

41.《脉经》“后”作“却”，“半”上无“小”字。

【消渴小便利淋病脉证并治第十三】

1. 《脉经》“吐蛔”无“蛔”。《注解伤寒论》辨厥阴病篇，“冲心”作“撞心”，“即”作“则”，“不肯止”作“利不止”。
2. 《脉经》“劳则荣气竭”作“迟则荣气竭”，“而大坚”作“而紧”，“洩数即坚”作“洩数则紧”，“坚数相搏”作“紧数相搏”。
4. 《注解伤寒论》卷三，“脉浮”前有“太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若”三十四字；“渴者”后有“与”字，无“宜利小便，发汗”六字。
5. 《注解伤寒论》“渴欲”上有“中风发热，六七日不解而烦，有表里证”十五字。
6. 《注解伤寒论》卷四，“文蛤五两”后有“味咸寒”三字，无“杵”字，“散”后作“以沸汤和一钱匕服，汤用五合”。
7. 《脉经》本条上有“师曰：热在下焦，则尿血，亦令人淋闭不通”十六字为冒。
8. 《脉经》本条后有“少阴脉数，妇人则阴中生疮，男子则气淋”十六字为尾。
9. 《金鉴》无“则”字。
10. 《心典》“苦渴”作“若渴”。
11. 《二注》“上三味”后有“以水四升，煮减半，去滓，温服七合，日三服”。《心典》“上三味”后有“先将茯苓、白术煎成，入戎盐再煎，分温三服”。《金鉴》作“上三味，以水五升，煮取三升，分温三服”。

【水气病脉证并治第十四】

1. 《脉经》“恶风”上有“其人”二字，“身”下有“体”字。《千金》卷二十一，“不渴”上有“不满”二字，“头面肿”之“肿”上有“并”字，“肘”作“浮”。
2. 《金鉴》按曰：“‘身体洪肿’之‘洪’字，当是‘浮’字。‘此为黄汗’四字，当是衍文。”
3. 《脉经》、《千金》无“蚕”字。《心典》作“窠上微肿”，作“如蚕新卧起状”。
4. 《心典》“酸”作“痠”，“脾胀”作“肺胀”。

5.《脉经》“黄肿”作“洪肿”，“此亡”无“此”字。《脉经》注云：“一云皮水其脉沉，头面浮肿，小便不利，故令病水，假如小便自利，亡津液，故令渴也。”《金鉴》按曰：“‘越婢加术汤主之’七字，当在后太阳病，脉浮而紧条内，发汗即愈之下，文义始属。必是错简在此。观其里有水之文，岂有用越婢加术汤发表之药，自可知也。”

7.《脉经》在“消谷”下注曰“一作消渴”。

8.《脉经》“则热”、“则潜”无“则”字，“即热”、“即止”无“即”字。

9.《脉经》“即恶寒”之“即”作“卫气不行，则”五字。

10.《脉经》“脉得”上有“师曰”二字，“沉”下有“者”字。

12.《脉经》“因肿”作“阴肿”。《辑义》云：“‘因肿’，据答语云当病水，作‘阴肿’为是。”

13.《脉经》“其人阴肿”作“其阴大肿”。《千金》“其身重”作“其人体重”，“阴肿”作“阴大肿”。

14.《脉经》“腹痛”作“腹中痛”，多“中”字。

15.《千金》“身”下有“体”字，“肿”下有“而”字。

17.《脉经》“面反瘦”作“面皮瘦”，注曰：“一云大便反坚”。

19.《脉经》注曰：“一云水分”。《脉经》卷九平妊娠胎动血分水分吐下腹痛证第二，“身肿”作“身体肿”。

20.《脉经》卷九，此条《脉经》分为两段，“此病难治”前为一段，“先病水”后为第二段。“病有血分水分何也？”作“病有血分何谓也？”“先病水”上有“问曰：病有水分何谓也？师曰”。“其经自下”作“其经自当下也”。《医统正脉》本缺此条。《心典》有此条，与本书同，与《脉经》不同。

21.《脉经》“脉之”上有“师”字，“肾气”作“紧气”，“胁下”作“胁上”，“攻击冲气”作“攻击卫气”。《心典》“当微”作“尚微”，“气击”作“气繫”，“后重”作“复重”，“浮咳喘逆”作“咳、喘逆”，无“浮”字，“攻击冲气”作“攻击卫气”。

22.《脉经》条文曰：“风水其脉浮，浮为在表，其人能食，头痛汗出，表无他病，病者言但下重，故从腰以上其和腰以下当肿及阴，难以屈伸，防己黄芪汤主之。”

23.《脉经》“无大热”作“而无大热者”。

24.《脉经》“为”上有“之”字。《外台》卷二十皮水方，“皮水为

病，四肢肿”作“皮水如肿”，“聂聂”作“集集”，无“者”字，“防己茯苓汤”作“木防己汤”，“桂枝”作“桂心”。

25.《外台》卷二十，作两条。一曰：“范汪皮水，一身面目悉肿，甘草麻黄汤主之。”又一曰：“《古今录验》，皮水，越婢汤加术主之方。”方后注云：“已上三方，并本出仲景《伤寒论》。”

26.《脉经》无“脉沉者”之“脉”字，“宜”作“与”字，“麻黄附子汤”作“附子麻黄汤”。《注解伤寒论》卷六，方名作“麻黄附子甘草汤”，麻黄“三两”作“二两”。

28.《脉经》“之为病”作“之病”，“肿”上有“洪”字，“蘖”作“蘖”，“脉自沉”上有“其”字，“何从”作“从何”，“从何得之”上有“黄汗之病”。

29.《脉经》“腰骹弛痛”误作“腰宽弛痛”。《心典》无“卧”字，“荣”作“营”，“必汗出”无“必”字，“饮热”作“啜热”。

30.《脉经》卷八，“阳前”、“阴前”二字之间均有“气”字。

31.《心典》“旋杯”作“旋盘”，无“水饮所作”四字。

32.《脉经》方名作“枳实术汤”。《肘后》治卒心痛方第八，曰：“治心下坚痛，大如碗，边如旋样，名为气分，饮水所结。方枳实七枚、炙术三两，水一斗，煮取三升，分为三服，当稍软也。”《辑义》按曰：“样，即盘字。”

附方

《外台》防己黄芪汤《脉经》方名在后。“为和”在《脉经》中作“其和”，误也。“其人”下有“能食”二字。“头”下有“痛”字。“病者”下有“言”字。

【黄疸病脉证并治第十五】

1.《脉经》“寸”上有“师曰”两字。

2.《脉经》“食即为满”作“食即满也”，“即发”作“则发”，女劳疸、酒疸各为别条。

3.《脉经》“头眩”下有“者”字，“小便必难”作“必小便难”。《注解伤寒论》无“者”字，“发”作“微”。

5.《脉经》“靖言了”作“靖言了了”。《外台》“靖言”作“静言”。《金鉴》“靖言”作“谿言”，无“了了”二字，“腹”上有“小”字。

6.《脉经》“吐之愈”作“吐之即愈”。

7.《脉经》“啖”作“噉”。《外台》“爪”作“抓”，无“虽黑微黄”四字。

8.《脉经》“以病发时”作“以发病时”，“面黄”作“而黄”。《金鉴》“两热所得”作“两热相得”。

11.《脉经》“黄疸”上有“师曰”两字，“以上”下有“为”字。赵刊本，“剧”作“极”。

12.《脉经》“疸”上有“又曰”二字，“阳部”上有“发于”二字。《千金》“其疸难治”、“其疸可治”的“疸”字皆作“病”字，“发热也”作“微热”，无“也”字。

13.《千金》“大黄二两”作“大黄三两”，方后注云：“右三味^㕮咀，以水一斗二升煮茵陈，得五升，去滓，内梔子、大黄煎取三升，分服一升，日三，小便当利如皂荚沫状，色正赤，当腹减，黄悉随小便去也。”

14.《脉经》“腹满者难治”作“腹满不可治”。《千金》“黄家”下有“至”字，“膀胱”上有“当”字，“少腹”作“小腹”，“身”作“体”，“腹胀”之间有“臌”字，“如水状”作“而满如欲作水状”，“时溏”下有“泄”字，“此女劳之病”作“此女劳疸”，“硝石矾石散”上有“治女劳疸”四字，无“烧”字，“等分”作“各半两”，“日三服”无“服”字，下有“重衣复取汗”五字，无“是候也”三字。

15.《外台》引仲景《伤寒论》“酒黄疸”作“酒瘕者”。《千金》、《外台》梔子作“七枚”，《千金》大黄作“三两”。

16.《千金》“家”作“疸”，“但”作“宜”，黄芪作“五两”。

17.《外台》引仲景《伤寒论》“乱发大如鸡子一枚”，方后注云：“右二味，内发膏中煎之，发消尽研，绞去膏细滓，分二服，病从小便去也”。

18.《外台》：“右二味和，先食白饮和方寸匕服之，日三。”

19.《外台》引仲景《伤寒论》，“疸”作“家”，“汗出”下有“者”字，“里实”下有“也”字，“当”作“宜”，“之”下无“宜”字，方名

作“大黄黄蘗皮梔子硝石汤方”。《千金》作“大黄汤方”。《外台》大黄作“四分”。《千金》、《外台》“顿服”上皆有“先食”二字。

20.《千金翼》“黄疸”上有“治”字，下无“病”字，“变”作“异”。

《千金》麻黄醇酒汤《千金》“治伤寒热出表发黄疸，麻黄淳酒汤方”，方后注云“以淳酒五升，煮取一升半，尽服之，温复汗出即愈，冬月寒时用清酒，春月宜用水”。《外台》引仲景《伤寒论》“黄疸，麻黄醇酒汤主之方”，麻黄作“一大把去节”，方后注又云“古今方云：伤寒热出表发黄疸，宜汗之则愈”。

【惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六】

1. 《脉经》“即”作“则”。
2. 《脉经》“师曰”上有“问曰：病衄连日不止，其脉何类？”十二字，“尺脉浮”作“脉来轻轻在肌肉，尺中自溢”，“未”上有“必”字。《金鉴》“尺”作“夫”。
3. 《脉经》“又”作“师”，“衄者”上皆有“发”字。
4. 《脉经》“不可”下有“发其”两字，“额上陷”作“额上促急而紧”，无“脉紧急”三字，“直视”下有“而”字。
5. 《脉经》“衄”下有“也”字。《心典》“无血色”作“无色”。《巢源》“无寒热”作“时寒时热”，无“脉沉弦者衄”、“烦咳者，必吐血”二句。
6. 《巢源》“咳逆”作“喘咳”，“脉数”下有“浮大”二字。
9. 《脉经》、《注解伤寒论》“亡血”下有“家”字，《脉经》“发”作“攻”。
10. 《脉经》“但欲”上有“其人”二字，“有瘀血”下有“当出汗不出，内结亦为瘀血”十一字。
11. 《心典》“如”下有“有”字。
12. 《二注》“洗去腥”无“去”字。
13. 《肘后》无方名，又曰“半夏，汤洗去滑干”。《二注》无“等分”二字。《心典》作“各等分”。
14. 《外台》“柏叶”作“青柏叶”，干姜作“二两”，方后注“右三味，以水五升，煮取一升，去滓，别绞取新出马通汁一升相和，合煎取一升，绵滤之，温分再服”。
15. 《脉经》“先”、“后”两字下皆有“见”字。《千金翼》：“凡下血者，先见血后见便，此为远血，宜服黄土汤。”
16. 《脉经》“先”、“后”两字下皆有“见”字。《千金翼》：“先见便后见血，此为近血，宜服赤小豆当归散。”当归作“三两”，方后注“右二味，捣筛为散，浆服一方寸匕，日三”。

17.《千金》“不足”作“不定”。“右三味”下有“**咬咀**”两字，无“顿”字。

【呕吐哕下利病脉证治第十七】

- 1.《脉经》“脓”下有“者”字。
- 2.《脉经》无“此属支饮”四字。《千金》“此属饮家”作“小半夏汤主之”。
- 3.《脉经》“故也”之间有“吐”字，“脉弦者”以下另作别条。《千金翼》无“问曰”、“何也”、“师曰”，“以发”之间有“医”字，无“令”字，“脉乃数”作“脉则为数”。
- 5.《千金》“脉紧”上有“趺阳”二字。《辑义》“涩则伤脾”作“虚则伤脾”。
- 7.《玉函》“视”作“问”。
- 8.《注解伤寒论》“茱萸”上有“吴”字，“水五升”作“水七升”，“取三升”作“取二升”，“二升”下有“去滓”两字。《千金翼》“日三服”下有“得汤反剧者，属上焦也”九字。
- 9.《千金翼》“头痛”上有“而复”二字，下无“者”字，“茱”上有“吴”字。
- 11.赵刊本、《注解伤寒论》芍药作“二两”。明刊本芍药作“三两”，半夏作“半斤”，生姜作“四两”。《注解伤寒论》生姜作“一两半”。
- 13.《外台》无“而”字与“解”字，“后”下有“必”字。《千金》猪苓、茯苓、白术各作“三两”。
- 16.《千金》、《外台》半夏作“三升”。《千金》人参作“二两”。《外台》“水”作“泉水”，“余分再服”作“日再服”，下并有“忌羊肉饴”四字。
- 17.《肘后》“治人胃反不受食，食毕辄吐出方”。《肘后》、《千金》、《外台》甘草皆作“二两”。《千金》“味下”有“**咬咀**”两字。《肘后》“分温”作“分为”。
- 18.《外台》“甘草（炙） 一两”，“桂枝”作“桂心”用“三两”，生姜作“三两”，“煮取三升”作“煮小麦三升，取五升”，“内泽泻”作“去滓，内

茯苓等”，无“温”字，“日三服”作“日再”。

20.《千金》“右二味**咬**咀，以浆水一升半，煮取七合，顿服之，日三”。

21.《外台》“胸中”作“胸内”，“啐”下无“彻”字，“无奈”作“彻无聊赖”，“生姜半夏汤”作“生姜汁半夏汤”，“煮半夏取二升”作“煎半夏取一升”，“小冷分四服”作“绵漉小冷，分二服”，“日”下作“一日一夜服令尽，呕啐一服得止者，停后服，禁羊肉饧”。

22.《千金》“厥者”之间有“冷”字，“味”下有“**咬**咀”两字，“温服一升，下咽即愈”作“分三服不止，更合服之”。

24.《脉经》“利”上有“下”字。

25.《脉经》“脉大”上有“其”字。

26.《脉经》无“冷”字，“无脉者”无“者”字。

27.《脉经》“而渴”作“其人渴”。《千金翼》无“今”字。

28.《千金》、《千金翼》“有”作“若”，“微热汗出”作“微发热，汗自出者”，无“今”字，“脉紧”之间有“复”字。

29.《千金》“渴”作“浮”。《千金翼》“脉”下有“反”字。

32.《脉经》无“者”字。

33.《脉脉》“胀满”下有“藏寒者，当温之”六字。

34.《脉经》、《千金翼》“病人”作“其人”，无“必”字。

35.《千金翼》“厥”下无“冷”字，“生”下无“脉”字。

36.《千金翼》无“胀”、“者”二字。《注解伤寒论》“稀”上有“热”字，“淋漓”下有“病必不除”。

37.《脉经》：“下利后，脉三部皆平，按其心下坚者，可下之。”

38.《脉经》“急”作“当”。

40.《脉经》：“下利差，至其年月日时复发，此为病不尽，当复下之。”

41.《脉经》“利”下有“而”字，“有”上有“为”字，“也”下有“宜下之”三字，无“小承气汤主之”。《千金翼》无“者”字。

42.《注解伤寒论》“剉”作“全用”，“温”下有“服”。

43.《千金翼》无“者”字，“愈”作“差”，“更服”下有“忌猪肉冷水”。

44.《注解伤寒论》“枚”下有“擘”字，“分”下有“为”，“得吐则止”作“得吐者，止后服”。

45.《千金翼》无“者”字。《注解伤寒论》“生用”下有“去皮，破八片”五字，“再服”下有“其脉即出者愈”。

46.《本草图经》“肺痛”二字，作“者”一字。

【疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八】

1.《千金》无“应”字，“洒淅恶寒”作“洗洗恶寒”，“当发其痈”作“当结为痈”。《注解伤寒论》无“反”字，“痛处”下有“饮食如常者”五字，“当发其痈”作“畜积有脓也”。

2.《脉经》“有脓”下有“与”字。

4.《脉经》无“痞”字，“即痛如淋”作“则痛”，“小便自调”作“小便数如淋”。《千金》牡丹作“三两”，瓜子作“一升”，芒硝作“二两”，方后注：“右五味^咬咀，以水五升，煮取一升，顿服之，当下脓血”。《心典》“瓜子”作“冬瓜仁”。

5.《脉经》无“浮”字，“若汗出”作“若从出”，“斧”作“器”。《心典》“不汗”下有“出”字。

【跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九】

1.《金鉴》“跌”作“跌”。

2.《二注》“此”作“其”。

3.《千金翼》“鸡屎白末，以水六合，煮取汤，服方寸匕”。

7、8.《二注》“令”作“今”，“闻”下无“食”字。《金鉴》“此”应作“非”。《注解伤寒论》“川椒去汗”作“蜀椒去子”，“臭等食”作“臭食等”。

【妇人妊娠病脉证并治第二十】

1. 《脉经》“名妊娠”作“名为躯”，“当有此证”作“当有娠”，“则绝之”下有“方在伤寒中”五字。
2. 《脉经》“妇人妊娠，经断三月而得漏下，下血四十日不止，胎欲动在于脐上，此为妊娠”，“六月动者”以下文句相同。《二注》“衄也”作“不血也”。
3. 《脉经》“其胎愈胀”作“其胎踰腹”，“腹痛恶寒者，少腹如扇”作“腹痛恶寒，寒者小腹如扇之状”。
4. 《脉经》“半产”作“半生”，“胞阻”作“胞漏”。
5. 《二注》“怀娠”作“怀妊”。
7. 《脉经》“妊”上有“妇人”两字。
8. 《脉经》“妊”上有“妇人”两字，“洒淅”作“洒洒”。
9. 《脉经》“主之”下有“即易产，无疾苦”六字。
10. 《外台》白术、芎^劳各作“四分”，牡蛎作“二分”，“杵为散”作“捣为筛”，“日三服，夜一服”无“服”字，“心烦吐痛”作“吐唾”，“大”下无“者”字，“服之后”无“后”字，“更”上有“复”字，“以”上有“亦”字，“已后”下有“其人若”三字，“愈”下有“尽”字，“勿置”下有“忌桃李雀肉等”六字。
11. 《玉函》“伤胎”作“伤寒”，“关元”作“小肠之募”，“小便微利”无“微”字。

【妇人产后病脉证并治第二十一】

1. 《脉经》“新产”下有“亡”字。
3. 《脉经》“日”下有“而”字，“此为胃实”作“此为胃热气实”，无“大”字，“主之”下有“方在《伤寒》中”五字。
4. 《脉经》“产后”上有“妇人”二字，“当归”上有“可与”两字，无“主之”，并治腹中寒疝，虚劳不足”十二字。
6. 《脉经》“腹痛”下有“烦满不得卧”五字，无“以”字及“主之”两

字，“宜”作“与”，无“亦主经水不利”六字。

7.《脉经》从“不大便”以下的文句为“不大便四五日，趺阳脉微实，再倍其人发热，日晡所烦躁者，不能食，谵语利之则愈，宜承气汤。以热在里，结在膀胱也，方在《伤寒》中。”

8.《脉经》“产后风”作“产得风”，“心下闷”作“心下坚”，“阳旦证”以下的文句为“阳旦证续在，可与阳旦，方在《伤寒》中，桂枝是也。”

9.《千金翼》“喘而”作“喘气”。

10.《脉经》“乳”作“产”。

11.《脉经》作“妇人热利重下，新产虚极”。《千金翼》“虚极”上有“兼”字。

《千金》三物黄芩汤“草蓐”无“草”字，“蓐”下无“自发露”，“四”上有“盖”字，“烦热”下接“皆自发露所为”六字，“头痛者”作“若头痛”，“烦者”作“烦热”，“此汤主之”作“与三物黄芩汤”。方后注：“右^咬咀，以水八升，煮取二升，去滓，适寒热，服一升，日三服，多吐下虫。”

《千金》内补当归建中汤“刺”作“^痠”，“少腹”作“小腹”，“摩痛引腰背”无“摩”字，“食饮”作“饮食”，“强壮宜”作“丁壮方”，“桂枝”作“桂心”，生姜作“六两”，大枣作“十枚”，“味”下有“^咬咀”两字，“三升”下有“去滓”两字，“加饴糖”作“内饴糖”，“暖令”无“暖”字，“若无生姜，以干姜代之”接在“饴消”之下，“去血”之上有“其人”两字，“衄”作“竭”，“味”作“种”，“八味”下有“去滓”两字。

【妇人杂病脉证并治第二十二】

1.《注解伤寒论》“续来”作“续得”，“经水适断”下有“者”字。

2.《脉经》“明了”作“了了”，“状”下无“者”，“无犯”上无“治之”，“及”作“若”，“必”下有“当”字。

3.《脉经》“得”下有“之”字，“凉”下无“和”字，“胸胁满”作“胸膈下满”，“谵”上有“其人”两字，“室”下无“也”字，“随其”下有“虚”字。《注解伤寒论》“满”上有“下”字。

4.《脉经》“下血”下有“而”字，“语”下无“者”字，“泻”作“写”，“愈”上有“则”字。《注解伤寒论》无“当”字。

5.《脉经》“齑”作“腐状”二字。《千金》“干苏叶”无“干”字，“味”下有“咬咀”两字，无“温”字，“一”下无“服”，下有“不差，顿服”四字。

6.《脉经》“躁”作“燥”，无“伸”字。《心典》“温分”作“分温”。

7.《千金》：“治妇人霍乱呕逆，吐涎沫，医反下之，心下即痞，当先治其涎沫，可服小青龙汤，涎沫止，次治其痞，可服甘草泻心汤方。”

8.《二注》“未”作“来”。

9.《脉经》“暮即”作“暮则”，“里急”下有“痛”字，“掌”下无“烦”字，“少腹”下有“中”字，“当以”作“当与”。《心典》“取”作“治”。

10.《本草纲目》土瓜条引此，“一月”上有“或”字。《金鉴》曰：“再”字当是“不”字。

13.《脉经》“如敦状”作“如敦敦状”，“俱结在血室也”作“并结在血室”。

19.《脉经》“师曰”以下的文句为“得病转胞不得溺也，何以故？师曰：此人故肌盛，头举身满，今反羸瘦，头举中空感一作减，胞系了戾，故致此病，但利小便则愈，宜服肾气丸，以中有茯苓故也”。

20.《脉经》：“妇人阴寒，温中坐药，蛇床子散主之。”

21.《脉经》“即”作“则”，“阴中蚀疮烂者，狼牙汤洗之”另作一条。

22.《脉经》“胃气”上有“师曰”两字，“阴吹”无“阴”字，“导”上无“煎”字。

【杂疗方第二十三】

2.“诃梨勒”下，赵刊本有“煨”字。

3.《千金翼》：“右叁味等分，先捣大黄干姜下筛，研巴豆如脂，内散中合捣一千杵，即用之。蜜和为丸亦佳，蜜器贮之勿令歇。主心腹暴病，若中恶客忤，心腹胀满刺痛，口噤气急，停尸卒死者，以水若酒服大豆许三四枚，捧头起令得下喉，须臾不差，更服三枚，腹中转鸣得吐利，即差。”《金鉴》“莫令歇”作“莫令泄气”。

4.《千金翼》有“人参一两”，“服”下有“三”字。

5.《千金翼》“活卒魔死方，捣韭汁灌鼻孔中，剧者灌两耳。注：张仲景云灌口中”。

又方：《肘后》“雄鸡冠割取血”作“割丹雄鸡冠血”。“鸡肝”作“鸡冠”。

6.《肘后》无“以”字。

7.《肘后》“骑”作“牵”，“灌”下有“之”字，“莢”下无“末”字。《千金》“吹皂莢末鼻中”作“末皂莢，吹鼻中”，无“立效”两字。

8.《肘后》“张口反折”作“张目及舌”。《千金》“巴豆者”下有“良”字。

9.《肘后》“牛洞”下无“稀粪也”三字，“口中”下有“洞者稀粪也”五字。《千金》、《外台》“洗之”作“洗足”。

10.《肘后》“救”上有“若”字，“方”作“者”，“狗屎”作“马矢”，“灌”作“吞”。

11.《肘后》冠以“张仲景云”四字，“蹶”上有“一”字，“舌下”下有“又云扁鹊法治楚王效”九字。《千金》“内”作“纳”。

又方：《肘后》无“取”字，“方”下有“二”字，“酒和”作“以酒”，“起”下有“也”字。《千金》无“剔”字。

12.又方：《肘后》乌梅作“二十个”，吴茱萸作“半斤”，“取”作“得”，“去滓分饮之”作“与饮之”。《外台》“水一斗”作“劳水一升”。

13.《外台》“救”作“仲景云”三字，“忿气”作“阴气”，“可治”作“可

疗”，“可治之方”作“犹可活”，“数动”作“微动”，“须臾”作“须令”，“桂汤”作“桂心汤”，“及稍止”作“乃稍止”，“若向”作“兼令”，“两人”下有“各”字，“采”作“弥”，“此法”无“法”字，“无不活也”作“无不活者，并皆疗之”。

14.《外台》“屈草带”作“屈革带”，“屈”上有“以”字，“两”作“四”，“溺”作“尿”，“热泥和屈草”作“泥土屈草”，“按及”作“若脱”，“喝人”下有“脐上”两字，“须”作“不”，“流去”下有“而已”两字，“卒”作“急”，“当令”下有“人”字，“其中”下有“仲景云”三字，“若”下有“有”字，“与之”下有“仲景云”三字，“不可”作“不用”，“泥土”作“土泥”。

15.《外台》引《小品》云：“疗溺死若身尚暖者方”。

【禽兽鱼虫禁忌并治第二十四】

13.《肘后》：“鸟兽自死，口不开者，不可食。”

20.《肘后》“犬”作“人”，“韭”作“薤”，“韭汁”下有“二三升，各连取以少水和之”十一字。

21.《肘后》：“此是郁脯煮大豆一沸，饮汁数升即解，兼解诸肉漏毒。”

25.《外台》“酸”作“骏”。

28.《千金》：“黄帝云：白马玄头，食其脑，令人癡。”

29.《千金》：“白马青蹄，肉不可食。”

33.《肘后》：“食马肝中毒，取牡鼠屎二七枚，两头尖者是，水和饮之，未解者更作。”《千金》：“治生食马肝毒杀人方。”

又方：《外台》“方寸”作“一钱”，“服之佳”作“立差”。

34.《千金》：“治食马肉血洞下欲死方。豉二百粒，杏仁二十枚。右二味^咬咀，蒸之五升，米下，饭熟捣之，再服令尽。”

又方：《千金》“饮之良”作“饮以浴即解”。

42.《肘后》“草”下有“饮汁一二升”，无“饮之即解”。

53.《外台》：“麋脂不可合梅李食。”

- 60.《外台》：“兔肉不可杂獭肉鸡心食。”
- 62.《外台》：“鸟兽自死，口不开，翼不合，不可食。”
- 64.《外台》作“鸡有六翻不可食”，无“四距者”、“之”四字。
- 70.《金鉴》“雀肉”下有“饮酒”两字。
- 82.《外台》“合”下有“白”字。
- 84.《外台》：“鯪鱼不可合鹿肉食之。”
- 87.《外台》：“龟肉不可合瓜及饮酒。”
- 88.《肘后》无“陷”字。《外台》“又”作“鳖”，“有”下有“如”字，无“形者”两字。《金鉴》“及厌”作“及腹”。
- 89.《肘后》“其”作“鳖”。
- 93.《金鉴》“鲙食之，在心胸间不化，吐复不出”作“脍食在胃不化，吐不出”。
- 94.《外台》：“疗食鲙过多，冷不消，不疗必成虫瘕方。马鞭草捣，绞取汁，饮一升即消去，亦宜服诸吐药吐之。”
- 95.《千金》：“治食鱼中毒，面肿烦乱者。”又“浓煎汁服之，即解”作“煮橘皮停极冷饮之，立验”。
- 98.《肘后》“三升”下作“以子汁饮之，亦治凡蟹未经霜多毒”。
- 99.《外台》“者”作“煮”。

【果实菜谷禁忌并治第二十五】

- 4.《金鉴》“病淋沥寒热”作“寒热淋沥病”。
- 5.《金鉴》：“一云：杀人。”
- 10.《千金》：“金疮产妇勿食，令人萎困寒中。”
- 13.《千金》：“动痰饮，令人恶心吐水吐食。”
- 14.《千金》“生枣”下有“味甘辛”三字，“寒”上有“若”字。
- 15.《千金》：“治食野菜马肝肉诸脯肉毒方。”“猪骨烧灰”作“烧猪骨末之”，“匕”下有“日三服”。
- 18.《金鉴》“柱”作“树”，“哭”作“笑”。

20.《肘后》：“蜀椒闭口者有毒，戟人咽气便欲绝，又令人吐白沫。多饮桂汁，若冷水一二升及多食大蒜即便愈。慎不可饮热杀人，比见在中椒毒含蒜及芥苳差。”

25.《千金》“勿食韭”下有“损人滋味”。

26.《千金》冠以“黄帝云”三字，“一切生菜”作“一切菜”。

27.《千金》“气”下有“起伏气”三字。

28.《千金》“神”下有“损寿”两字。

29.《千金》“伤心脉”作“伤血脉”。

30.《千金》：“十月、十一月、十二月勿食生薤。”

31.《千金》：“四季之月，土王时勿食生葵菜，令人饮食不化，发宿病。”

32.《千金》：“时病差后未健，食生青菜者，手足必青肿。”

34.《千金》无“生”字，“光”下有“泽”字，“目涩”下无“痛”字，“腰疼，或发心疟，疟发时”作“又疟发心痛，腰疼，或致心疟发时”，“委”作“痿”。

39.《千金》：“生葱共鸡犬肉食，令人谷道终身流血。”

43.《千金》冠以“黄帝云”三字，“病”作“疾”。

45.《千金》冠以“黄帝云”三字，无“内”字。

46.《千金》：“黄帝云：不可共酪食，必作虫。”

51.《千金》“动病”作“动宿冷”。

54.《金鉴》“咳”作“核”。

58.《千金》：“**咬**咀，以水六升，煮取三升，冷如人体，服五合，日三夜二，凡煮芥苳惟令浓佳。”

60.《肘后》“手背腹满”作“手青肚满”，“各”作“作”，下无“治之方”三字，“硬糖二三升”作“服硬糖三二升”，无“右一味”、“服之”，“三五枚”作“三二个”，“差”上有“便”字。

61.《肘后》“黎”作“黍”。

64.《千金》“噉”作“食”。

65.《千金》“作**癰**”作“多力健行”。

68. 《千金》无“人”字，“肺”下有“喜咳，令人色肤黑，损筋力”十字。

79. 《千金》“已”作“竟”，“吐”下有“或成霍乱”。



现代著名老中医名著重刊丛书

刘渡舟医书七种



经方

临证指南

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编
■ 刘渡舟 主编

第十辑



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·第十辑
刘渡舟医书七种

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编



经方 临证指南

主编 刘渡舟
协编 姜元安

人民卫生出版社

版权页

图书在版编目（**CIP**）数据

经方临证指南/刘渡舟主编. —北京：人民卫生出版社，2013

（现代著名老中医名著重刊丛书.第10辑，刘渡舟医书七种）

ISBN 978-7-117-17357-5

I. ①经... II. ①刘... III. ①经方-临床应用-指南 IV. ①R289.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第120942号

人卫智网 **www.ipmph.com** 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台

人卫官网 **www.pmph.com** 人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

现代著名老中医名著重刊丛书（第十辑）

刘渡舟医书七种

经方临证指南

丛书主编：王庆国 刘燕华

主 编：刘渡舟

出版发行：人民卫生出版社有限公司

人民卫生电子音像出版社有限公司

地 址：北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编：100021

E - mail: ipmph@pmph.com

制作单位：人民卫生电子音像出版社有限公司

排 版：人民卫生电子音像出版社有限公司

制作时间：2013年1月

版本号：V1.0

格式：mobi

标准书号：ISBN 978-7-117-17357-5

策划编辑：李丽

责任编辑：李丽

打击盗版举报电话：**010-59787491** E-mail: **WQ@pmph.com**

注：本电子书不包含增值服务内容，如需阅览，可购买正版纸质图书。

刘渡舟医书七种编写委员会

主 编

王庆国 刘燕华

副主编

李宇航 梁永宣

编 委（以姓氏笔画为序）

于博睿 马小娜 马春雷 王 冬 王庆国

王国华 王利敏 王雪茜 刘 敏 刘丹彤

刘晓倩 刘晓辉 刘燕华 闫军堂 许仲宁

孙 燕 孙良明 孙晓东 李 欣 李成卫

李宇航 李丽娜 李晓莉 李鹏英 吴范武

张 欢 张 娜 张雪亮 陈 明 陈 萌

畅洪昇 周 刚 郑丰杰 房克英 屈会化

赵 妍 赵 琰 赵伟鹏 赵宇明 钟相根

贾春华 倪 磊 高 飞 郭书文 梁永宣

程发峰 傅延龄 鲁 艺 赛佳洋

学术秘书

闫军堂

出版说明

自20世纪60年代开始，我社先后组织出版了一些著名老中医经验整理著作，包括医案、医论、医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国现代中医学术的发展发挥了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显。这些著名老中医在我国近现代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。他们的著作多成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前。无论是亲自撰述，还是口传身授，或是由其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华。诸位名老中医不吝秘术，广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，今已很难见到，部分著作甚至已成为中医读者的收藏珍品。为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将部分具有较大影响力的名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》并分辑出版，以飨读者。

第一辑 收录13种名著

- | | |
|-------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |
| 《钱伯煊妇科医案》 | 《朱小南妇科经验选》 |
| 《赵心波儿科临床经验选编》 | 《赵锡武医疗经验》 |
| 《朱仁康临床经验集——皮肤外科》 | |

《张赞臣临床经验选编》

第二辑 收录14种名著

《中医入门》 《章太炎医论》

《冉雪峰医案》 《菊人医话》

《赵炳南临床经验集》 《刘奉五妇科经验》

《关幼波临床经验选》 《女科证治》

《从病例谈辨证论治》 《读古医书随笔》

《金寿山医论选集》 《刘寿山正骨经验》

《韦文贵眼科临床经验选》 《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑 收录20种名著

《内经类证》 《金子久专辑》

《清代名医医案精华》 《陈良夫专辑》

《清代名医医话精华》 《杨志一医论医案集》

《中医对几种急性传染病的辨证论治》

《赵绍琴临证400法》 《潘澄濂医论集》

《叶熙春专辑》 《范文甫专辑》

《临诊一得录》 《妇科知要》

《中医儿科临床浅解》 《伤寒挈要》

《金匱要略简释》 《金匱要略浅述》

《温病纵横》 《临证会要》

《针灸临床经验辑要》

第四辑 收录6种名著

《辨证论治研究七讲》 《中医学基本理论通俗讲话》

《黄帝内经素问运气七篇讲解》 《温病条辨讲解》

《医学三字经浅说》 《医学承启集》

第五辑 收录19种名著

《现代医案选》 《泊庐医案》

《上海名医医案选粹》 《治验回忆录》

《内科纲要》 《六因条辨》
《马培之外科医案》 《中医外科证治经验》
《金厚如儿科临床经验集》 《小儿诊法要义》
《妇科心得》 《妇科经验良方》
《沈绍九医话》 《著园医话》
《医学特见记》 《验方类编》
《应用验方》 《中国针灸学》
《金针秘传》

第六辑 收录11种名著

《温病浅谈》 《杂病原旨》
《孟河马培之医案论精要》 《东垣学说论文集》
《中医临床常用对药配伍》 《潜厂医话》
《中医膏方经验选》 《医中百误歌浅说》
《中药炮制品古今演变评述》 《赵文魁医案选》
《诸病源候论养生方导引法研究》

第七辑 收录15种名著

《伤寒论今释》 《伤寒论类方汇参》
《金匱要略今释》 《杂病论方证捷咏》
《金匱篇解》 《中医实践经验录》
《罗元愷论医集》 《中药的配伍运用》
《中药临床生用与制用》 《针灸歌赋选解》
《清代宫廷医话》 《清宫代茶饮精华》
《常见病验方选编》 《中医验方汇编第一辑》
《新编经验方》

第八辑 收录11种名著

《龚志贤临床经验集》 《读书教学与临症》
《陆银华治伤经验》 《常见眼病针刺疗法》
《经外奇穴纂要》 《风火痰瘀论》

《现代针灸医案选》 《小儿推拿学概要》

《正骨经验汇萃》 《儿科针灸疗法》

《伤寒论针灸配穴选注》

第九辑 收录11种名著

《书种室歌诀二种》 《女科方萃》

《干祖望医话》 《名老中医带教录》

《班秀文妇科医论医案选》 《疑难病证治》

《清宫外治医方精华》 《清宫药引精华》

《祝谌予经验集》 《疑难病证思辨录》

《细辛与临床》（附 疑难重奇案七十三例）

第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）

《伤寒论十四讲》 《伤寒论通俗讲话》

《伤寒论诠解》 《新编伤寒论类方》

《经方临证指南》 《金匱要略诠解》

《肝病证治概要》

这些名著大多于20世纪60年代前后至90年代后在我社出版，自发行以来一直受到广大读者的欢迎，其中多数品种的发行量达到数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床诊疗水平和促进中医事业发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时尽可能保持原书原貌，只对原著中有欠允当之处及疏漏等进行必要的修改。为不影响原书内容的准确性，避免因换算等造成的人为错误，对部分以往的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的临床检测项目与方法等，均未改动，保留了原貌。对于原著中犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社
2013年3月

整理说明

刘渡舟是北京中医药大学已故终身教授、《伤寒论》专业首批博士生导师，当代著名的中医学大家、中医教育家。刘老行医、执教半个多世纪，上溯岐黄之道，下逮诸家之说，力倡仲景之学，博采众长，学验宏富，形成了鲜明的学术思想和医疗风格，被誉为“伤寒泰斗”、“经方大家”，日本汉方界更称其为“中国治伤寒第一人”，其学术成就为中医同仁所公认，在中医学界享有盛誉。刘老以振兴中医、培育桃李为己任，在繁忙的医疗、教学、科研之余，坚持著书立说，笔耕不辍，培养后学。刘老一生著述颇丰，曾出版中医学术著作20多部，发表学术论文100余篇，为传承中医药事业作出了杰出贡献。

20世纪80年代，刘老的学术经验日臻成熟与完善，在当时十多年的时间里，他出版了数十部关于《伤寒论》、《金匱要略》及经方运用的研究专著，具有很高的学术水平和临床应用价值，深受广大读者欢迎，在中医学界产生了很大的影响，对于推动仲景学术发展和提高中医临床水平起到了重要的作用。为了系统总结刘老的学术思想和医疗经验，并从中窥探其治学方法与道路，我们精选了最能反映刘老治伤寒、用经方、精临证的学术著作，经撰次整理，辑而成帙，名为《刘渡舟医书七种》，付梓再版，以飨读者。这7本代表性医书分别是《伤寒论十四讲》、《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论诠解》、《新编伤寒论类方》、《经方临证指南》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》。这些著作能突出反映刘老之方证相对论、辨证知机论、古今接轨论、气机论、攻邪论、水火论、湿证论、脾胃论、肝胆论以及抓主证等学术思想及其对经方的运用经验，汇集了刘老行医50余年的学术经验和心血结晶，贯彻了理论和实践相结合的方针。通过阅读刘老文稿，读者可窥其学术思想和临床经验之一斑，并有助于系统地掌握刘老的临证特色和诊治经验。编撰者也希望通过这些文字笔墨展示经方大家刘渡舟教授的学术经历及成就，使一代名家为中医药事业不屈不挠的奋斗精神、人格品质及宝贵经验得以传世后人，为中国医学史树起一座不朽的丰碑。

为了使读者能原汁原味地阅读刘老著作，本次修订再版《刘渡舟医

书七种》时，采取尽可能保持原书原貌的原则，除对原著中出现的文字、标点错误稍加更正，并在不影响文意的前提下润色语句不通顺之处外，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排，从而规范了原书的体例层次。而对原书中出现的古今字、异体字、繁简字以及以往的病名、药名、计量单位等，均未改动，保留了原貌。

2007年，为了整理、挖掘、继承和抢救京城名老中医的学术经验，北京市中医管理局启动了“名老中医药专家学术思想抢救挖掘与优秀传承人才培养联动工程”（简称“薪火传承3+3工程”），目的在于做好首都名老中医学术思想的抢救、整理和挖掘工作。刘渡舟名家研究室

（No.2007-SZ-A-09）于2007年10月首批获北京市中医管理局批准，2008年1月授牌，2008年6月正式启动建设，进行了大量卓有成效的工作。将刘老积累多年的学术著作、文章、讲稿等整理、汇编、出版更是研究室的重要工作之一，本书即是在研究室全体成员的共同努力之下完成的，在此，谨向名家研究室这一名老中医学术经验平台的发起者——北京市中医管理局致以崇高的敬意。同时，也向所有参与此次编撰工作的各位同仁致以谢意。

刘渡舟名家研究室主任
北京中医药大学副校长，教授、博士生导师
王庆国
2012年12月

刘渡舟简介

刘渡舟，辽宁营口人，1917年生，中医伤寒学家，北京中医学院教授，博士生导师。

曾任中国中医药学会常务理事，中国中医药学会仲景学说专业委员会主任委员，《北京中医学院学报》名誉主编，国务院学位委员会第三届学科评议组特约成员，北京中医药研究促进会名誉会长。

刘氏于16岁正式拜师学医，凡7年之久，不唯对《内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒论》、《金匱要略方论》等中医典籍勤学精研，且对后世名家医著多有用心，加之好学敏思，精读强记，打下了坚实的理论及临床基础。出师后悬壶大连，每以奇方起大症，愈沉痾，故医名噪起。

1950年进入卫生部中医进修学校深造，学习西医基础及临床课程，毕业后继续行医于北京城区。1956年调到北京中医学院工作，一直从事《伤寒论》的教学和研究，历任伤寒教研室副主任、主任，金匱教研室主任，中医基础部负责人等职。

刘氏从事中医五十余年，在长期的理论研究和临床实践中，逐步形成了独特的学术思想和医疗风格。他认为《伤寒论》六经辨证有其脏腑经络的物质基础，六经之实质为经络、脏腑、气化的统一体，而《伤寒论》是主论外感风寒，兼论内伤杂病的辨证论治专著，故而六经辨证可统摄伤寒杂病，以之广泛应用于临床各科。

此外，刘氏还对《伤寒论》的条文排列、六经提纲证、标本气化理论在分析六经生理病理中的重要意义等也有独到见解。他除在全国各中医期刊发表大量论文外，还著有《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论十四讲》、《伤寒论诠解》、《伤寒挈要》、《新编伤寒论类方》、《伤寒论辞典》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》、《伤寒论校注》等。其中，《伤寒论通俗讲话》和《伤寒论十四讲》在日本翻译出版，名为《中国伤寒论解说》。《伤寒论校注》荣获1992年国家科技进步二等奖。

在临床方面，刘氏善于诊治多种疑难重证，推重经方，然而知守善变不落窠臼，不薄时方，兼通诸家，并蓄其长，且根据自己的实践经验创制了许多有效方剂，因而在内、妇、儿科的治疗中，均有极高的效验。

序

在五十多年的行医生涯中，我陆陆续续地写了不少行医笔记，记在许多小本本之上，其中有医理的发挥，但更多的是真实地记录了在临床运用经方所治之验案，因其涣漫散在，一直没有成文而问世。

门人姜元安，敏而好学，酷喜岐黄之道，更爱仲景之术。一日见余曰：“经方治病，效如桴鼓，医林无不称善。但要真正做到善用经方治病，则非轻而易举之事。先生之临床经验宏富，上溯仲景，下逮李、朱、吴、叶等人，皆有创新之见及临床治疗之妙，如能将其整理归纳，厘其层次，使其系统可观，刊行于世，这对中医药之学术以及临床之士谅亦不无小补。”

余既嘉其言，又感其志诚，乃将所藏之手稿尽授于姜，命其整理。凡七年有余，数易其稿，始归纳成集，名曰《经方临证指南》。共选经方99首，附方5首，226例医案，每案详解其辨证要点、病机关键、方药作用特点等，务求切合临床实用之所需。

医圣张仲景作《伤寒杂病论》，尝曰“虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源”。余水平有限，其中错误难免，请读者批评指正为幸。

刘渡舟
1993年4月10日于北京

Table of Contents

上篇 经方临证治验录

- 1.桂枝汤证
- 2.桂枝加葛根汤证
- 3.桂枝加附子汤证
- 4.桂枝去芍药汤证
- 5.桂枝去芍药加附子汤证
- 6.桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证
- 7.桂枝加桂汤证
- 8.桂枝加龙骨牡蛎汤证
- 9.桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证
- 10.桂枝加芍药汤证
- 11.桂枝加大黄汤证
- 12.桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤证
- 13.黄芪桂枝五物汤证
- 14.麻黄汤证
- 15.麻黄加术汤证
- 16.桂枝二麻黄一汤证
- 17.桂枝二越婢一汤证
- 18.葛根汤证
- 19.葛根加半夏汤证
- 20.小青龙汤证
- 21.大青龙汤证
- 22.麻黄杏仁甘草石膏汤证
- 23.越婢加半夏汤证
- 24.越婢加术汤证
- 25.桂枝甘草龙骨牡蛎汤证
- 26.茯苓桂枝白术甘草汤证
- 27.茯苓桂枝甘草大枣汤证
- 28.茯苓甘草汤证
- 29.苓桂杏甘汤证
- 30.五苓散证

[31.桂枝去桂加茯苓白术汤证](#)
[32.桃核承气汤证](#)
[33.抵当汤证](#)
[34.栀子豉汤证](#)
[35.栀子厚朴汤证](#)
[36.大陷胸汤证](#)
[37.大陷胸丸证](#)
[38.小陷胸汤证](#)
[39.大黄黄连泻心汤证](#)
[40.附子泻心汤证](#)
[41.半夏泻心汤证](#)
[42.生姜泻心汤证](#)
[43.甘草泻心汤证](#)
[44.旋覆代赭汤证](#)
[45.黄连汤证](#)
[46.黄芩汤证](#)
[47.白虎汤证](#)
[48.白虎加人参汤证](#)
[49.白虎加桂枝汤证](#)
[50.白虎加苍术汤证](#)
[51.调胃承气汤证](#)
[52.小承气汤证](#)
[53.大承气汤证](#)
[54.麻子仁丸证](#)
[55.厚朴七物汤证](#)
[56.茵陈蒿汤证](#)
[57.麻黄连翘赤小豆汤证](#)
[58.栀子柏皮汤证](#)
[59.小柴胡汤证](#)
[60.大柴胡汤证](#)
[61.柴胡桂枝汤证](#)
[62.柴胡桂枝干姜汤证](#)

[63.柴胡加龙骨牡蛎汤证](#)
[64.小建中汤证](#)
[65.理中汤证](#)
[66.桂枝人参汤证](#)
[67.四逆汤证](#)
[68.四逆加人参汤证](#)
[69.白通汤证](#)
[70.桃花汤证](#)
[71.真武汤证](#)
[72.黄连阿胶汤证](#)
[73.猪苓汤证](#)
[74.猪肤汤证](#)
[75.半夏汤证](#)
[76.四逆散证](#)
[77.吴茱萸汤证](#)
[78.白头翁汤证](#)
[79.白头翁加阿胶汤证](#)
[80.当归四逆汤证](#)
[81.干姜黄芩黄连人参汤证](#)
[82.芍药甘草汤证](#)
[83.甘草附子汤证](#)
[84.桂枝附子去桂加白术汤证](#)
[85.竹叶石膏汤证](#)
[86.牡蛎泽泻散证](#)
[87.百合地黄汤证](#)
[88.防己黄芪汤证](#)
[89.苇茎汤证](#)
[90.旋覆花汤证](#)
[91.甘姜苓术汤证](#)
[92.酸枣仁汤证](#)
[93.射干麻黄汤证](#)
[94.大黄牡丹汤证](#)

- [95.泽泻汤证](#)
- [96.半夏厚朴汤证](#)
- [97.桂枝茯苓丸证](#)
- [98.当归芍药散证](#)
- [99.温经汤证](#)

[下篇 医论集](#)

- [1.张仲景当归剂的证治特点](#)
- [2.心悸的辨证与治疗](#)
- [3.人体的“津液链”](#)
- [4.“战汗”的发生、治疗及护理](#)
- [5.苏子降气汤证的病理特点及其临床运用](#)
- [6.温胆汤的临床运用](#)
- [7.加减木防己汤治疗湿热痹](#)
- [8.温病证治约言](#)
- [9.阴虚性肝胃不和的证治](#)
- [10.益胃汤的临床运用](#)
- [11.三甲复脉汤的临床运用](#)
- [12.“甘温除大热”及东垣方的临床运用](#)

[返回总目录](#)

上篇 经方临证治验录

1.桂枝汤证

（1）时发热自汗出案

李某，女，53岁。患阵发性发热汗出已经一年多，每天发作2~3次，饮食及大、小便基本正常。曾经按阴虚性发热治疗，服药二十多剂无效。脉缓而软，舌质淡苔白。《伤寒论》说：“病人脏无他病，时发热自汗出而不愈者，此卫气不和也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤”。

桂枝9克 白芍9克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草6克 二剂。

服药后啜热稀粥，得微汗出而愈。

【解说】

桂枝汤的主要治疗作用是调和营卫，既可以用来治疗外感风寒所引起的营卫不和，也可以用来治疗内伤杂病中的营卫不和。本案治疗的要点在于“病人脏无他病”，而又年过50岁，由于天癸已竭而阴气偏弱，使得阴阳二气不相谐和，所以出现阵发性的发热汗出。桂枝汤调和营卫，实际上也就是调和阴阳。因为营卫代表了阴阳的两个方面，营行脉内即为阴，卫行脉外即为阳。所以，用桂枝汤调和营卫以达到调和阴阳之目的，是本方取得疗效的关键。

（2）风疹案

某男，60岁。患风疹，皮肤瘙痒，钻心难忍已数月。伴见汗出、恶风等证，脉浮缓，舌苔白润。此为风邪稽留肌肤，营卫失和所致。当用解肌祛风，调和营卫之法治疗。

桂枝9克 白芍9克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草6克 三剂。

服药后喝热稀粥，得微汗出，痒止疹消，皮屑脱落而愈。

【解说】

风疹以皮肤瘙痒为主要临床表现，因为其发病部位在于皮肤腠理之

间，一般属于阳证，所以《灵枢·终始》说：“痒者，阳也”。本证虽然多见于血热受风，但也有不少是由于外感风邪，邪气稽留于肌表而营卫失和所引起。识别是否由于外感风邪所引起的一种标志在于伴随恶风或遇风则发，属于此类证型的，用桂枝汤治疗最为有效。

（3）汗出偏沮案

孙某，男，39岁。患左半身经常自汗出，而右半身反无汗，界限非常分明。无其他明显不适，脉缓而略浮，舌苔薄白。用桂枝汤调和营卫阴阳，使其相将而不相离则愈。

桂枝9克 白芍9克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草6克 三剂。

服药后啜热稀粥，得微汗出而愈。

【解说】

凡汗出偏于肢体一侧，或左或右，浸润不止者，都是由于营卫气血有所偏伤，阴阳失于和调所引起。这种“汗出偏沮”，如果不及时的治疗，久而久之，卫气不能固护于外，营气不能守护于内，就有可能导致半身不遂的“偏枯”证。《素问·生气通天论》说：“汗出偏沮，使人偏枯”。本病往往由于外感风邪而引起，所以用桂枝汤解肌发汗以祛风邪，调营卫，和气血以顾正气，乃是一种正治的方法。不然的话，风邪凝滞营卫，汗出损伤气血，经脉不通，筋骨失养，那么，“偏枯”证就随时可能发生。

2.桂枝加葛根汤证

口眼^喎斜案

张某，女，26岁。在乘长途汽车回家途中，靠窗倚睡而受风。回家后，突然感到左侧面部肌肉拘紧，口眼向左侧^喎斜。脉浮，舌苔白润。此风邪客于阳明经络，治疗当以祛风通络为主。

桂枝9克 白芍9克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草6克 葛根15克 白附子6克 全蝎6克

服药二剂，汗出邪去而愈。

【解说】

阳明经脉行于面部，经脉受邪，所以，面肌拘紧，口眼^喎斜。^喎斜见于左侧，是风邪客于右侧，而被左侧正气所引。如《金匮要略·中风历节病篇》所指出的：“络脉空虚，贼邪不泻，或左或右，邪气反缓，正气即急，正气引邪，^喎僻不遂”。用桂枝加葛根汤治疗，一方面可以解肌祛风，另一方面疏经通络，解除经脉气血的凝滞，同时，葛根还能升达阳明津液，滋阴润燥，以缓解经脉的拘急。临床上还常用本方来治疗冠心病的胸背疼痛，以及高血压动脉硬化所引起的后脑部疼痛等证。

又附：项背强痛案¹

张某，男，51岁。有冠心病史，平时胸闷，头晕而沉。近一月来出现头项强痛，甚至及于后背，伴汗出，恶风，纳呆，肢体乏力，舌体胖大而嫩，苔白腻，脉弦大无力。辨为饮气内据，外及太阳经脉。治疗用桂枝加葛根汤，又加茯苓30克、白术6克，服药六剂后，汗出恶风及头项背强痛皆止，其他症状亦有明显改善。

3.桂枝加附子汤证

房后伤风案

王某，男，25岁。患者身材高大，体魄雄伟。夏季某日与妻子同房后，因觉燥热而置两腿于窗户之上，迎风取爽。几天后，左腿疼痛，左小腿拘挛而屈伸不利，针药屡治不效。脉弦迟，舌苔水滑。

桂枝18克 附子12克 白芍9克 生姜9克 炙甘草6克 大枣7枚 木瓜9克 独活6克

服药二剂后，痛止腿伸而愈。

【解说】

房事之后，精泄而内虚，不知慎护，但图凉爽，使风邪乘虚而入。《素问·风论》说：“入房汗出中风，则为内风”。脉弦迟而舌苔水滑，则阳气内虚。外来之风邪，必须从外解而去；阳气内虚，则必兼顾正虚。选用桂枝加附子汤外解风邪，内壮阳气，再加木瓜以利筋骨，加独活以散风气。此外，本方还常用来治疗老年人因阳气不足而感受寒邪，见症以脉沉而汗出恶风为主，可以起到温经扶阳，正邪兼顾的作用。

1 注：凡书中注明“又附”医案的皆为姜元安所治，下同。

需要指出的是，桂枝加附子汤原本是治疗“漏汗”的，《伤寒论》说：“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之”。可见，漏汗的产生是由于发汗太过，阳气不能固摄津液，导致津液外泄。桂枝加附子汤，不仅能够温补阳气，而且还能通过补阳而达到摄阴止汗的目的，临床上用来治疗顽固性的自汗证也每奏奇效。

又附：漏汗案

崔某，女，51岁。患自汗证十多年，屡经中西医治疗而不愈。患者每日自汗出不止，浸湿内衣，每日换衣3~4次，一年四季皆如此。上半身汗出多于下半身，左半身汗出甚于右半身，稍有劳作更甚，伴有恶风，肢体屈伸不利。其人体态肥胖，但终日感觉体疲乏力。舌质淡嫩，苔白而脉缓。辨为阳虚漏汗证，用桂枝加附子汤。

服前三剂时有奇特的反应，每次服药后约一小时左右，自觉全身皮里肉外有一种如冰雪融化般的感受。三剂药后，汗出情况大为好转。又加大附子剂量，再进三剂。服第四剂药后，周身皮肤之内出现针刺般的

疼痛感觉，2小时后，疼感消失，顿觉舒适无比。六剂药服尽，而十年之自汗已止。用桂枝汤加黄芪、白术各10克善后痊愈。

4.桂枝去芍药汤证

胸闷案

李某，女，46岁。因患心肌炎而住院治疗，每当入夜则胸中憋闷难忍，气短不足以息，必须靠吸氧气才能得以缓解。舌质淡苔白，脉弦而缓。辨为胸阳不振，阴气内阻之证。

桂枝10克 生姜10克 大枣12枚 炙甘草6克

服药二剂后症状减轻，原方加附子6克，再服三剂后，症状消除。

5.桂枝去芍药加附子汤证

胸痛案

王某，男，46岁。多年来胸中发满，或疼痛，往往因气候变冷而加剧。伴有咳嗽，短气，手足发凉，小便清长等证。舌质淡嫩，苔白略滑，脉沉弦而缓。此乃胸阳不振，阳不胜阴，阴气窃踞胸中，气血运行不利。治疗当以温补心阳，以散阴寒为主。

桂枝9克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草6克 附子10克

连服六剂，证情逐渐减轻，多年的胸中闷痛，从此得以解除。

【解说】

桂枝去芍药汤与桂枝去芍药加附子汤，都是桂枝汤的加减方。这两个方子的共同特点是它们都具有振奋胸阳的作用，这种作用首先都是通过桂枝汤去芍药而得以实现的。因为桂枝汤的组方特点是阳中有阴，若去掉酸寒阴柔之性的芍药，就变为辛温扶阳之剂。如果在此基础上再加上辛温气雄的附子，使其补阳的作用就更为突出。

胸闷或胸痛是“胸痹”的主要临床表现，其产生的主要病机在于上焦心胸阳气虚弱而阴寒之气内盛，所以《金匮要略·胸痹心痛短气病篇》说：“阳微阴弦，即胸痹而痛”。因为“胸为阳位似天空”，心肺二脏居其内，营卫二气由此而得以宣发。如果胸阳不振，阴寒内凝，则阳气不能布达而痹阻，心肺之气血不畅。所以，胸痹的临床表现，轻者胸中满闷，重者就以疼痛为主。

6.桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证

产后身痛案

樊某，女。产后半月许，忽然身体疼痛，脉来沉迟，无感冒可言。有学员辨为气血两虚，用十全大补汤治疗，虽有小效但不彻底。改用桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤治疗，服药三剂后，疼痛消除。

桂枝9克 白芍12克 生姜12克 大枣12枚 炙甘草6克 党参12克

【解说】

本方用于发汗后，或妇女产后，或流产后，或行经后，血虚而营气不足，不能充养肢体而出现的身体疼痛，脉沉涩而无力。方中用桂枝汤调补营卫；加重白芍剂量以养营血；另加人参以补卫虚。本方最妙之处在于加重生姜的剂量，借其辛散之力而走于外，使全方的益气养血作用达于体表，补而不滞，专治营卫气血不足所引起的身体疼痛。《金匱要略·血痹虚劳病篇》中的黄芪桂枝五物汤也重用了生姜，与本方之义同。

7.桂枝加桂汤证

奔豚病案

崔某，女，50岁。患奔豚病，自觉有一股气从下往上走窜，行至小腹则胀，上抵心胸则气短心悸，头冒冷汗。少顷气往下行，则诸证随之而消。每次发作时精神特别紧张恐怖，如临死亡，每日发作二三次。平时少腹及腰部有酸疼感，带下多，面色青黄不泽。舌体胖，舌质淡嫩，苔白润，脉弦数但按之无力。辨为心阳虚弱坐镇无权，以致下焦浊阴乘虚上犯。治疗当温补心阳，而消阴降冲。

桂枝15克 白芍9克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草6克 黑锡丹6克（用药汤送服）

一剂药服尽，冲气已止。共进五剂而愈。

【解说】

奔豚病发作的一般情况是气从少腹上冲胸咽，发作时恐怖欲死，气复还则止，这在临床上亦比较常见，但发作程度如本案这样严重的并不多见。导致奔豚病产生的机理大多是由于心阳不足，不能坐镇于上，因而下焦阴寒邪气得以上冲。奔豚病的发作特点是：凡奔豚气所经过的部位，必然使正常的气机运行闭塞，而出现憋闷胀满，心悸，汗出等证。桂枝加桂汤，是治疗奔豚病的一个有效方剂，《伤寒论》指出：“气从少腹上冲心者……与桂枝加桂汤，更加桂二两也”。更加桂在于取桂枝强心通阳，开结气，降冲气，用来治疗奔豚病最为合拍。有的医家认为，“加桂”应是加肉桂。如果从临床应用的角度来看，加桂枝和加肉桂，效果基本相同。

8.桂枝加龙骨牡蛎汤证

遗精案

王某，男，20岁。患有遗精证半年，几乎每夜均有发生，屡经医治无效，形体疲惫不堪。病初之时，每因有梦而遗精，逐渐发展为无梦而遗。舌质淡嫩不泽，脉弦缓无力。辨证属于心肾阴阳不交而精关弛废失禁。

桂枝10克 白芍10克 生姜10克 大枣12枚炙甘草6克 龙骨15克 牡蛎15克

连服五剂后，滑精止，饮食增进，精神渐振，从此调治而愈。

【解说】

《金匮要略·血痹虚劳病篇》说：“夫失精家，桂枝加龙骨牡蛎汤主之”。所谓“失精家”，是指有长期遗精、滑精史的人，初起时，往往由于欲火内动，而又不能随心所愿，以致心火内燃，下扰肾精，逼迫精液外泄，所以常常表现为有梦而遗精；久而久之，肾元下亏，失却固摄功能，导致精关弛废不固，最终发展为无梦而走泄，成为“失精家”。所以，失精家的病机关键在于心肾阴阳上下不交，治法以调和阴阳，交通心肾为主。桂枝汤能和营卫，调和脾胃，而调和阴阳，加龙骨、牡蛎一方面能收敛神气，固摄精关，另一方面也起到固护心肾精气的作用。

9.桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证

神乱案

董某，男，28岁。因精神受到刺激而犯病，心中烦躁不安，或胆怯惊怕，或悲伤欲哭，睡眠不佳，伴有幻听、幻视、幻觉“三幻症”，胸中烦闷难忍。舌苔白厚而腻，脉弦滑。辨为肝气郁滞，痰浊内阻而上扰心宫。

桂枝6克 生姜9克 蜀漆4克（以常山代替）龙骨12克 牡蛎12克 黄连9克 竹茹10克 郁金9克 菖蒲9克 胆星10克 大黄9克

服药二剂，大便作泻，心胸顿觉舒畅。上方减去大黄，又服三剂后，突然呕吐痰涎盈碗，从此病证大为减轻。最后用涤痰汤与温胆汤交替治疗而获痊愈。

【解说】

在《伤寒论》中，仲景用桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤治疗由于火劫迫汗，损伤心阳而引起的惊狂，卧起不安；本案取意于此方而用来治疗由于情志内伤所导致的神志迷乱。二者病因不同，证情有别，但其病机则基本一致，即心神内乱而兼有痰郁。正如清代医家柯韵伯所指出的那样：“不拘病之命名，惟求症之切当，知其机得其情……宜主某方，随手拈来，无不活法”。但火劫亡阳的治疗重点在于温通心阳而补其虚，所以用甘草、大枣甘温之品，以起到辛甘合化为阳的作用；而本案则偏重于涤痰清热以开心窍，所以加上竹茹、胆星、菖蒲、郁金、黄连和大黄，同时去掉大枣、甘草以防其助湿化痰。这是临床上随证加减，灵活论治的一个体现。

蜀漆乃常山之苗，其功用与常山相似，有较强的催吐祛痰作用。用量一般在3~5克，但还要注意水炒先煎，以减少其对胃肠的刺激而消除致吐等副作用。如果药店不备蜀漆，也可用常山代替。从临床运用来看，用蜀漆和大黄黄连泻心汤及远志、菖蒲合用，治疗属于痰热上扰，蒙闭清窍所致的精神分裂症，效果较好。服药后或吐或泻，或吐泻交作，吐则多为痰涎，泻则多为胶黏秽物，其后都能使精神安定下来。

10.桂枝加芍药汤证

（1）虚利案

王某，男，46岁。因患急性细菌性痢疾，未经彻底治疗而转为慢性菌痢。大便下痢，挟有红白黏液，每日少则三四次，多则五六次。来势甚急，常常来不及登厕就内污衣裤，但又后重下坠，大便排而不尽。伴腹中隐隐疼痛，肠鸣作响。病程逾年，曾用真人养脏汤，以及芍药汤等治疗，皆无效可言。脉沉弦而滑，舌质红苔白。再三审证，辨为脾胃阴阳失调，气血不利之证。

桂枝9克 白芍18克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草9克

二剂后，下利次数减为一二次，腹痛肠鸣消失。原方又进二剂，诸证皆消。

【解说】

本案病机要点在于脾胃阴阳失调，中焦气血不利。脾胃居中，为气机升降之本，气血阴阳之所主。脾虚则清气不升，胃虚则浊气不降，土气不和，则必然导致肝木郁滞，疏泄失常。此类病证非寒非热，介于虚实之间，所以用寒热之法治治疗都不能取效。桂枝加芍药汤能够调和脾胃之阴阳，利血脉消瘀滞，并有平肝缓急之效，于调和脾胃中兼能疏泄肝木。

（2）腹痛案

张某，女，32岁。每当午后即觉腹中疼痛，痛时自觉腹肌向内抽掣拘急。饮食二便基本正常，但月经衍期，每次行经需10天左右，经色黑紫，挟有血块。脉弦细如按刀刃，舌质绛紫，苔薄白润。证属脾之气血不和，而肝木横逆克犯脾土。治宜平肝缓急，调和气血。

桂枝10克 白芍30克 生姜10克 大枣12枚炙甘草10克

连服六剂，腹痛止，拘急解。转方用当归芍药散而愈。

【解说】

柯韵伯称桂枝汤为仲景群方之魁，乃滋阴和阳，调和营卫，解肌发汗之总方。而桂枝汤之所以能滋阴和阳，调和营卫，则首先在于其能调和脾胃之气。众所周知，营卫生成于水谷，而水谷转输于脾胃，所以，脾胃之气旺盛则营卫生化之源充足，营卫和调则气血阴阳随之也和。从桂枝汤组方的五味药物来看，桂枝、生姜、大枣、炙甘草，自古以来都

是厨房中常用的调料，有健脾开胃，促进食欲的作用，所以桂枝汤实际上擅能调补脾胃，通过调补脾胃，然后达到启化源，滋营卫，益气血，和阴阳的目的。只有明了这一道理，然后才可以了解本案的治疗方法。重用白芍，使其能和脾阴，利血脉，又能柔肝缓急以止疼痛。

临床上凡见有腹满时痛，下利，舌质偏红，苔薄白而脉弦细者，多属脾胃气血阴阳失和，选用本方治疗，每能取效。

11.桂枝加大黄汤证

久利案

李某，男，36岁。患慢性痢疾，多年屡治不愈。大便下痢挟有红白黏液，里急后重，每日三四次，伴腹满疼痛拒按。脉弦有力，舌质绛苔黄。此证虽然脾胃气血不和，但又挟有阳明凝滞之实邪，积邪不去，则下利不能止。治法当加大黄以通腑气，扫除肠中腐秽。

桂枝9克 白芍18克 生姜9克 大枣10枚 炙甘草6克 大黄6克 三剂。

嘱一次煎煮顿服。服药后大便畅利，泻下皆黏腻臭秽之物，而后下利日渐轻缓。

【解说】

桂枝加大黄汤，即桂枝加芍药汤方再加大黄而成。《伤寒论》说：“本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之；大实痛者，桂枝加大黄汤主之”。本案的辨证要点是在桂枝加芍药汤证的基础上，又见腹痛拒按，大便秘结，脉按有力，舌绛苔黄等实证。

12.桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤证

气胀案

董某，女，49岁。周身皮肤肿胀，随按随起而无凹陷，腹部胀满尤为明显。更有奇者，肚脐周围出现如栗子大小包块十余个，按之软，随按而没，抬手又起。腹部皮肤发凉，间或暖气上逆，面色黧黑不泽。脉沉无力，舌苔白。该证病名为“气分”，属寒邪内搏气机所致。

桂枝9克 生姜15克 大枣10枚 炙甘草6克 麻黄6克 细辛4.5克 附子9克 川椒3克

服三剂后腹中气动有声，矢气甚频，肤胀随之消减，脐周之包亦消。但腹中胀满尚未尽愈，改方用李东垣寒胀中满分消汤，三剂而愈。

【解说】

“气分”这一病名，见于《金匱要略·水气病篇》中。究其病因病机有二：一方面是由于营卫俱虚而不利，另一方面是在于心肾阳虚而寒邪内搏。所以，病证表现在外的有皮肤肿胀而发凉，表现在内的有脘腹胀满而起包。《灵枢·水胀》曾说：“肤胀者，寒气客于皮肤之间，**𦵔𦵔**然不坚，腹大身尽肿，皮厚，按其腹窅而不起，腹色不变”。所以治疗“气分”病证当以调和营卫，温阳散寒，通利气机为主。张仲景指出：“气分……桂枝去芍药加麻辛附子汤主之”。桂枝汤去芍药即成温补之剂，能通心阳，散阴寒而和营卫，麻黄辛温宣发，散外寒，利肺气；细辛、川椒温中散寒，利气消阴；附子温补心肾阳气，以使内外阳气通利，营卫俱行。即所谓“阴阳相得，其气乃行，大气一转，其气乃散”。

13.黄芪桂枝五物汤证

（1）血痹案一

融某，男，61岁。患头晕病史三年之久，近来自觉左太阳穴处如虫蚁爬行状，左侧肢体麻木不仁，经多方医治无效。脉浮大无力，舌苔薄白。

生黄芪40克 桂枝12克 生姜12克 白芍12克 大枣7枚 六剂。

服药后头晕明显好转，太阳穴处虫蚁爬行感消失，肢体麻木亦减轻。乃改用黄芪为50克，另加当归10克，再进六剂后，诸症全部消失。三个月后随访，未见反复。

（2）血痹案二

李某，男，49岁。一年多前，患者开始发现四肢感觉逐渐迟钝，慢慢发展为肌肤麻木不仁，肢体强直，屈伸不利，行步不稳，头重脚轻如踏棉花，伴见腰痛，腹部拘紧如有束带。经CT检查，发现C₂~C₆椎管狭窄，确诊为脊髓型颈椎病，建议用手术治疗。由于患者有所顾虑而转请中医治疗。舌苔白略腻，脉来涩迟。辨为气虚血滞，“血痹”之证。

生黄芪40克 桂枝10克 白芍10克 生姜15克 大枣12枚

上方服二剂后，各种症状均有减轻。原方加大剂量，改黄芪为50克，桂枝12克，加牛膝10克，又进六剂后，患者两腿已能行走，不用他人搀扶而来就诊。在上方基础上加木瓜10克，另开：泽泻15克，白术10克，以利水湿之邪，二方交替服用共约四十余剂，上述症状全部消退，恢复正常工作。半年后来信致谢，病情一直没有复发。

【解说】

“血痹”病是一种以肌肤麻木不仁为主要临床表现的病证，其病机在于营卫不足，气血阴阳俱弱，由于外受风寒邪气而使阳气痹阻，血行不畅所以被称为血痹。该病的脉象以虚涩微紧或浮大无力为主，治疗应采用调补营卫，益气和血的方法，张仲景立黄芪桂枝五物汤为其治疗的主方。该方有三个特点：其一，以桂枝汤为主调和营卫并能解肌祛风。其二，加黄芪重在益气，取意于气行则血行，血行则痹通。临床上有时加当归同用，目的是为了加强益气活血的作用。由于黄芪甘温，补卫气而行于表，所以桂枝汤中去炙甘草。其三，桂枝汤中倍用生姜，取其外散走表，载芪、桂之力而行于外，也是临床取效的关键，不可忽视。

14.麻黄汤证

太阳伤寒证案

刘某，男，50岁。因工作需要，自北京赴甘肃省。当时正值隆冬季节，不慎冒受风寒而得“太阳伤寒证”。发热，39.8℃，严重恶寒，周身大小关节无一不痛，身无汗，咳嗽，脉浮紧。

麻黄9克 桂枝6克 杏仁12克 炙甘草3克一剂。

服药后，盖被躺火炕上发汗。约1小时左右，遍身然汗出而解。

【解说】

麻黄汤是《伤寒论》中治疗太阳伤寒证的第一名方。张仲景说：“太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之”。归纳起来，可以分为寒热，诸痛与无汗而喘三组证候。太阳伤寒证的病机关键在于寒邪外束，卫气闭郁，营阴不得畅行，简称为“卫闭营凝”。因为表闭无汗，所以又称之为“表实证”。

表实证与表虚证的“卫强营弱”不同。前者以无汗为特点，后者以汗自出为特点。由于卫阳被寒邪所闭郁，营阴被寒邪所凝滞，所以用麻黄汤辛温发汗以散寒，目的在于发越闭郁之阳气，而使营阴畅行。服药后必须要微微汗出为佳，用药时要注意麻黄：桂枝：炙甘草的剂量比例应该是3：2：1，否则就会影响发汗的效果。

服用麻黄汤一般都能汗出，与服桂枝汤啜粥取汗有别。但应当注意，服麻黄汤后也有不汗出的情况。从曹颖甫《经方实验录》中所记载的几则医案中看，可以将服麻黄汤后不汗出的情况概括为以下三种：一是表证未解而先用下法，导致中气虚弱而无力作汗，这种不汗出是由于误治；二是久居寒冷之地或平时习惯于寒冷之气，轻易不容易受到风寒的侵袭，如果一旦受之，所感邪气必定比一般人要严重，如果用药剂量不足就不能发汗，这种不汗出是与地域、职业有关；三是有的患者服药后，阳气发动，化水为气，汗出于无形而不被发觉，也好像不汗出。诸如此类情况，变化难测，所以临证时要细心推求其理，就不至于惊慌失措。

更需要一提的是，由于麻黄汤有较强的发汗作用，使用不当又会产生许多变证，不少临床医家视之如虎狼，畏而不敢用。其原因主要在于：一是临床辨证不明确，对于伤寒病与温热病的鉴别心中无数，所以

一见发热为主的病人，多从温热病方面治疗。《伤寒论》指出：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病”。这里突出地强调了温病“口渴”与“不恶寒”乃是诊断的主要依据。如果不出现口渴，证候表现仍有恶寒特点，还是应该考虑风寒的病情。因此，外感初起口渴与不渴，是识别寒、温的一个苗头。另一方面原因主要是医家受温病学说影响，畏其辛温形成一种偏见，其实，只要在准确辨证的前提下，用麻黄汤治疗伤寒表实证是唯一最有效的方剂。

又附：小儿伤寒案

张某，男，2岁。患发热，39℃，他医用辛凉法治疗而反增剧。症见：形寒，头痛，咳嗽痰白，始终无汗，病已3日，脉仍浮紧，舌苔白润。按太阳伤寒表实辨证，投以麻黄汤：炙麻黄6克，桂枝4克，杏仁10克，炙甘草2克。药后约半小时，即汗出热退，一剂服尽而愈。

15.麻黄加术汤证

水肿案

高某，女，37岁。患浮肿八年，每每因遇寒冷而加剧，曾经西医诊断为黏液性水肿，多方求治无效。患者全身浮肿，以颜面部为甚，伴恶寒，肢体沉重疼痛，无汗，胸脘痞满，小便不利，大便常秘。舌苔白滑，脉浮紧。

麻黄9克 桂枝6克 杏仁10克 炙甘草3克 苍术10克 三剂。

每次服药后，均有微汗出。三剂服尽，肿消，其他各症亦随之而愈。为巩固疗效，以苓桂术甘汤善后。

【解说】

麻黄加术汤是张仲景用来治疗“湿家，身烦疼”的一张方剂，具有发散寒湿的治疗作用。本案所治的水肿，属于《金匮要略》中“水气病”的范畴。在《水气病篇》中，张仲景并没有提出麻黄加术汤这一治法，为什么在此却用本方治疗？患者全身浮肿，但以颜面部为甚，张仲景在论治水气病时提出：“诸有水者，腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗乃愈”。麻黄汤为发汗之剂，所以用来发汗以消肿，此其一；本案除了浮肿外，还见有明显的肢体沉重疼痛，恶寒无汗，舌苔白滑等寒湿在表的症状，符合麻黄加术汤所治寒湿郁遏卫阳这一病机，此其二；服用麻黄加术汤后，不但能够发散在外的寒邪湿气，而且可以宣畅肺气，恢复肺的治水功能，使其通调水道，下输膀胱，驱湿邪从小便而出，此其三。所以，临床审证施治，贵在证机相符，方证合拍，切不可拘泥而失其变通之义。

又附：头痛案

张某，男，38岁。初春之时，因骑自行车过猛，汗出而受风。自述左侧风池穴处疼痛剧烈，以致夜不成眠，无其他症状，但不汗出。舌苔滑腻，脉弦紧有力。予麻黄加术汤原方：麻黄10克，桂枝6克，杏仁15克，苍术10克，炙甘草3克。每次服药后皆得微汗出，服一剂后，疼痛明显减轻，二剂服尽，头痛已消。

【解说】

本案辨证关键在于疼痛部位在风池穴处。该穴位于后项，属太阳经所主，虽然症状不兼备，但由于表实无汗，所以用麻黄汤治疗。加苍术

是因为舌苔滑腻，兼有湿象，因而用术以化湿。

16.桂枝二麻黄一汤证

类疟案

刘某，女，12岁。初春感受风寒邪气，头痛发热，家人自购“平热散”，服药后汗出较多，随后发热消退。但第二天发热恶寒如疟疾之发作，上午一次，下午二次。脉浮略数，舌苔薄白而润。究其原因，属于发汗太过，在表之邪气反而稽留不解，当用桂枝二麻黄一汤小汗之法治疗。

桂枝5克 白芍5克 生姜5克 大枣3枚 麻黄3克 杏仁3克 炙甘草3克 一剂。

药后得微微汗出而解。

【解说】

《伤寒论》指出：“服桂枝汤，大汗出……若形似疟，一日再发者，宜桂枝二麻黄一汤”。这里所说的“形似疟”，是指发热恶寒发作的情况，而不是真正的疟疾。大凡先发热而后恶寒，或发热恶寒同时并存，寒热一天发作两次或数次，大都属于太阳病变，往往是由于表证发汗太过，既损伤营卫正气，又未能使邪气彻底外解，这是辨证时需要注意的。正如曹颖甫所说：“少阳病之所以异于太阳者，以其有间也。若日再发或二三度发，则为无间矣”。无论伤寒或中风，只要是表邪稽留日久不解，而且证情较轻，寒热如疟者，都可以用本方治疗。临床上这类病证多见于年幼或年老，以及久病体弱的患者。

17.桂枝二越婢一汤证

类症案

刘某，女，10岁。深秋感受寒凉之气，发热恶寒，每日发作好几次，拖延数月未愈。脉浮无力，舌质红苔薄白，饮食及大小便基本正常。此种情况属于风寒郁表，日久不解，寒将化热的轻证。治用桂枝二越婢一汤。

麻黄3克 桂枝5克 白芍5克 生姜3克 大枣4枚 生石膏6克 炙甘草3克 玉竹3克

共服二剂，得微汗出而解。

【解说】

本案患者的临床表现与上案基本相同，都是发热恶寒一日之内发作数次的类症证，但不用桂枝二麻黄一汤反而用桂枝二越婢一汤治疗，是因为其舌质红，反映表邪有入里化热的趋势。张仲景说：“脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤”。历代不少注解《伤寒论》的医家认为“此无阳也”是指亡阳而言，而不知本条所说的“无阳”是指邪气欲离于表而言。成无己曾说：“表证罢为无阳”。这是因为伤寒脉象一般为浮紧，脉象由浮紧而变弱，则反映了寒邪将要离开肌表而有入里化热的趋势，所以不用单纯辛温的麻桂合方，而用辛温之中兼有石膏另加玉竹辛凉清热滋液为治。

18.葛根汤证

口噤案

崔某，女，18岁。病口噤难以开合，勉强用力可张口2厘米左右，若再用力则两颊疼痛难忍，经北京某医院诊断为颞颌关节炎，半月未愈。舌苔黄白相杂，脉弦。

葛根24克 生石膏24克 玉竹9克 丹皮9克 白芍9克 钩藤9克 甘草3克

服药三剂后，口能张开容下两指，原方又服三剂，口张进食如常人。

【解说】

口噤不能张，病位在阳明经，因为足阳明胃的经脉循行于口颊部。邪气客于阳明经脉，气血不利，所以口不能开合自如。从舌苔黄而知经中有热，故用药只取葛根汤加减。重用葛根作为方中的主药，它既能疏通阳明经络，又能启阳明津液以濡养经脉，如陈修园所说：“葛根以清经络之热，是发表中寓养阴之意也”。从《金匱要略》中可以看出，仲景用葛根是作为止痉的专药。本案用石膏为臣，清阳明经中热邪；佐以白芍、丹皮、钩藤、玉竹而成养阴凉血息风之法。所以，读仲景书，用仲景方，如果能深明其用药之法，则随证取舍，无不合乎法度。

又：在《伤寒论》中，葛根汤是用来治疗太阳经脉被寒邪所伤，经脉气血不利所致的“项背强，无汗，恶风”等证，它与桂枝加葛根汤所治的项背强的主要区别点在于有汗与无汗。

又附：头项强痛案

朱某，男，55岁。外感风寒，患头项部强直疼痛已2天。伴肢节疼痛，恶寒，无汗，口不渴，舌苔白，脉数有力。治用葛根汤原方：

葛根15克 麻黄10克 桂枝10克 生姜10克 白芍10克 大枣10枚 炙甘草6克

服药后，始觉后背发热，继而布达全身，汗出。两剂愈。

19.葛根加半夏汤证

二阳合病案

程某，女，25岁。初春感寒后，患发热，头痛，恶风寒，呕吐，面色红赤。脉浮，舌苔白润。证属二阳合病，治用葛根加半夏汤。

葛根12克 麻黄6克 桂枝6克 生姜6克 半夏9克 白芍6克 大枣7枚 炙甘草6克

二剂。服药后汗出热退，呕吐止。

【解说】

本案为太阳与阳明合病。发热，恶风寒，头痛而脉浮，是病在太阳经；面色红赤，呕吐是病在阳明经。《伤寒论》说：“阳明病，面合赤色，不可攻之”，说明了面色红赤是属于阳明经表的病变。经中有邪，就会使在里脏腑之气失和，所以胃气上逆而呕吐。治疗“合病”的一个基本原则是根据邪气偏重于哪一经，做到分清主次，二经兼顾。本案就是根据这一原则选用葛根汤，治疗重点在太阳经，同时兼顾阳明。如尤在泾所说：“邪盛于外而之内者，仍当先治其邪”。

20.小青龙汤证

（1）寒饮咳喘案

张某，男，40岁。患咳喘病多年，每当发作之时，自服“百喘朋”能缓解症状。此次犯病，发作严重，又来求取“百喘朋”。当问及为何不愿服用汤药时，才知道原先曾服中药无数，但未见效果。经过反复劝说后，同意服汤药一试。喘咳痰多，脉弦，舌苔水滑。观其面色黧黑，辨为寒饮内伏，上射于肺的小青龙汤证。

麻黄9克 桂枝9克 干姜9克 细辛6克 五味子9克 半夏9克 白芍9克 炙甘草9克 二剂。

服药后喘咳明显好转，转用茯苓桂枝杏仁甘草汤加干姜、五味子，又服三剂，喘咳得以基本控制。

【解说】

小青龙汤是张仲景用治寒饮咳喘的一张名方。或伤寒表不解，心下有水气；或膈间有支饮，凡属寒饮内伏，上射于肺所致的咳喘，皆有明显功效。本方合干姜、细辛及麻、桂于一体，辛烈走窜，虽然药力峻猛，但只要掌握好辨小青龙汤证的几个环节，临床运用则效如桴鼓。①辨气色：寒饮为阴邪，易损伤阳气，使阳气不能上荣于面部，而面呈黧黑之色。或双目周围呈现对称性黑圈，叫做“水环”；或头额、鼻柱、两颊、额下之皮肤出现黑斑，称为“水斑”，二者统称“水色”。②辨脉：寒饮内伏的脉象多见脉弦或沉弦，如果是表寒内饮，则多为浮紧之脉。③辨舌：寒饮内伏，是由于津液凝聚不化所致，所以舌苔往往表现为水滑或滑润，而舌质一般为淡嫩而胖。④辨痰涎：肺寒气冷，津凝为痰，所以咳喘往往多痰，或痰涎清稀不稠，形如泡沫，落地为水；或痰稠但明亮晶彻，状如鸡蛋清，冷如凉粉。⑤辨咳喘：或咳重而喘轻，或喘重而咳轻，或喘咳皆重，但必定是咳逆倚息不得卧，平卧则加剧。⑥辨兼证：寒饮内伏可以兼有或噎、或呕、或小便不利而身肿、或头痛发热等证，都是由于水饮随气机流动而引起。以上六个辨证环节，是正确使用小青龙汤的客观依据，但六个辨证环节并不必悉具，只要有其中一两个主证，便可使用小青龙汤治疗。

小青龙汤治疗重证寒饮咳喘，疗效卓著，屡用屡效。但此方辛烈峻猛，能伐阴动阳，下拔肾根，用药必须中病即止，不可久服。根据《金匮要略》中提出“病痰饮者，当以温药和之”的原则，用苓桂剂善后则疗

效理想。

（2）过服小青龙汤救逆案

某男，患咳喘痰多，不能平卧，咳吐稀白泡沫状痰，面色黧黑，脉弦紧，舌苔白滑。证属寒饮射肺，投以小青龙汤原方两剂。患者持方后，没有再来复诊。第二年春见其面色^晄白不泽，身形羸弱，自云服药颇有疗效，喘息咳痰皆明显好转，夜能平卧，喜出望外，按原方又继续服用十二剂后，发生头晕，心悸，夜难成眠等证。自冬至节后，忽一日发生鼻衄，来势汹涌，不能自止，经某医院用电烙法止血，从此自觉神疲乏力，所以又来诊治。这是过服小青龙汤发散太过，拔动肾根，伤阴动血发生的变证。乃用人参养荣汤加龙骨、牡蛎等药，连服数十剂后，体力才逐渐得以恢复。

【解说】

小青龙汤属于辛烈走散，作用峻猛的方剂，久服有伐阴动阳之弊。但由于患者不知此理，持方久服，发散太过，阳气不密，导致少阴肾精不固。待冬至节后，天阳启动，阴精不能密藏则见伤阴动血，鼻衄不能自止的情况。大、小青龙汤，都是在麻黄汤辛温发散的基础上衍化而来，具有很强的发散作用。张仲景立大、小青龙二方，一方面阐明其证治特点，另一方面又指出其救逆之法，目的就在于告诫人们要注意服药后的一些不良反应。如针对大青龙汤证指出：“若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。服之则厥逆，筋惕肉^瞤，此为逆也。”又说：“汗出多者，温粉粉之”。至于小青龙汤的治疗禁忌、误治变证以及救逆的方法，则在《金匱要略·痰饮咳嗽病篇》中有详细的论述：“青龙汤下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难，时复冒者，与茯苓桂枝五味甘草汤，治其冲气。冲气即低，而反更咳、胸满者，用桂苓五味甘草汤，去桂加干姜、细辛以治其咳满……”学者如果能细心体会仲景设苓桂剂既治水饮之邪，又御小青龙汤之变，则得心应手，庶几近之。

溢饮案

21.大青龙汤证

某女，32岁。患两手臂肿胀，沉重疼痛，难于抬举，经过询问得知，冬天用冷水洗衣物后，自觉寒气刺骨，从此便发现手臂肿痛，沉重酸楚无力，诊脉时颇觉费力。但其人形体盛壮，脉来浮弦，舌质红绛，苔白。此证属于水寒之邪郁遏阳气，以致津液不得流畅，形成气滞水凝的“溢饮”证。虽然经过多次治疗，但始终没有用发汗之法，所以缠绵而不愈。

麻黄10克 桂枝6克 生石膏6克 杏仁10克 生姜10克 大枣10枚 炙甘草6克

服药一剂，得汗出而解。

【解说】

“溢饮”是水饮病的一种表现形式，临床以身体疼痛沉重，其形如肿为特点。用大青龙汤治溢饮，这在《金匮要略》中已有明确论述。仲景在《伤寒论》中也有关于用大青龙汤治疗“溢饮”证的论述，原文第39条说：“伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之”。这一条注家见解不一，有的注家认为，从所描述的症状特点来看，这也属于溢饮的范畴。但《金匮要略》偏重于内因，指出溢饮病是由于“饮水流行，归于四肢，当汗出而不汗出”所致；而《伤寒论》则偏重于外因，属于寒邪留着于四肢肌肤之间，郁闭卫阳，使气机不行，津液凝涩所致。二者起因不同，但临床表现则基本一致，所以都用大青龙汤发越阳郁，汗出阳气通利，津液流畅则愈。

又附：伤寒高热案

黄某，男，28岁。隆冬感受寒气，症见：高热，体温39.5℃，恶寒，头身肢节皆痛，无汗，心烦，口不渴。病已3天，曾用柴胡注射液，服A.P.C及桂枝加葛根汤无效。舌红苔白，脉浮紧有力。此寒郁化热，治当发汗。

麻黄 10克 桂枝6克 杏仁10克 生石膏15克 大枣10枚 生姜10克 炙甘草6克 一剂。

初服无汗，复服后汗出遍体，浸渍衣裤，发热等证随汗出而解。

22.麻黄杏仁甘草石膏汤证

疹伏不透案

郑某之子。初春出麻疹，因感染风寒，疹出未透而骤回。症见：高热，体温39.8℃，气喘鼻煽，环口发绀，疹伏不出，若隐若现。脉数而滑，舌苔黄褐而干。此为疹毒内陷，火热犯肺，证情险恶，急当宣肺清热，透疹达邪。

麻黄2.4克 杏仁9克 甘草1.5克 生石膏18克 羚羊角1.2克 瓜蒌仁6克 桑叶6克 浙贝6克

服药一剂后热退喘平，前胸后背透发疹点甚多，但仍咳嗽，转用桑菊饮加蝉衣、贝母、竹茹、玉竹等药调理而愈。

【解说】

大凡小儿出麻疹，应该以麻疹透尽为顺，内伏不出为逆，而且在出疹期间一定要慎避风寒。本案患儿因感染风寒而使疹毒内陷伏而不出，是临床危重证之一，治疗一定要以清热透邪为主，麻杏甘膏汤是首选的良方，加羚羊角清肺平肝不但治咳喘，又能防热极生风，产生惊厥；加桑叶疏风宣肺透疹；加瓜蒌仁、浙贝，化痰利肺以助麻、杏外透之功。

仲景用麻杏甘膏汤治疗肺热阳盛的汗出而喘证。对比麻黄汤，二方皆可治喘，但麻黄汤证之喘是由于寒邪闭表，肺气不宣，所以是无汗而喘；麻杏甘膏汤证之喘是由于热邪客肺，肺气壅塞，所以是汗出而喘。二者虽有寒热之别，但总是离不开肺气闭塞这一特点。闭者当开，所以都用麻黄以开之。因寒邪而闭塞者，配桂枝辛温以开之，因热邪而闭塞者，配石膏辛凉以开之。

又附：肺热咳嗽案

李某，男，2岁。初得伤寒，高热，39℃，无汗，舌苔白润，脉浮数。予麻黄汤原方一剂，服药后得汗出，发热降至37.5℃，但又出现严重咳嗽，呼吸气急，有痰，汗出，舌红苔略黄，脉滑数。此为邪气化热闭肺所致，急疏麻杏甘膏汤，服两剂后，热退咳平。

23.越婢加半夏汤证

肺风案

王某，男，58岁。患有肺气肿病五年多，病情逐年加重。现症：胸闷气短，喘息头晕，项背恶风，寸脉浮，舌质红苔白。辨为“肺风”挟饮之证。

麻黄5克 生姜10克 半夏10克 生石膏15克 大枣7枚 炙甘草6克 三剂。

服药一剂后得微汗出，则觉胸中之满顿开而呼吸随之畅利，三剂后项背恶风亦消。又加石膏25克，服三剂，气喘已平。

【解说】

《素问·风论》说：“风中五脏六腑之俞，亦为脏腑之风”。说明了脏腑之风，是风邪外袭，从脏腑所在背部的输穴内传于里。肺的输穴叫“肺俞”，位于后背第三胸椎下旁开1.5寸，风邪从肺俞内传于肺，则为肺风。《风论》指出：“肺风之状，多汗恶风，色皛然白，时咳，短气，昼日则差，暮则甚”。张仲景广《内经》之义，指出：“肺中风者，口燥而喘，身运而重，冒而肿胀”。由此可见，“肺风”证的临床表现应该有以下四个方面的症状：①多汗恶风；②咳喘短气；③头晕目眩；④肢体肿胀而重。根据这些情况来看，本案似属“肺风”之例，但仲景并没有提出治疗肺风的方剂。我们发现越婢加半夏汤所治的“肺胀”，与肺风的证候近似，所以可补肺风治疗之不足。

24.越婢加术汤证

溢饮案

吕某，男，46岁。病四肢肿胀，肌肉酸疼已十多天，西医诊断为末梢神经炎。其人身体魁梧，面色鲜泽，但手臂沉重，抬手诊脉亦觉费力。按其手足凹陷成坑，而且身有汗但四肢无汗。舌质红苔腻，脉浮大。按溢饮证治疗。

麻黄12克 生姜9克 生石膏30克 苍术12克 大枣7枚 炙甘草6克 二剂。

服药后四肢得微汗出，病证明显减轻，原方加桂枝、苡米、茯苓皮等，又服两剂而愈。

【解说】

本案用越婢加术汤治疗溢饮证，是从张仲景用大青龙汤治溢饮中受到启示。大青龙汤去掉桂枝、杏仁就成为越婢汤。大青龙汤治疗风寒闭郁阳气的不汗出而烦躁，以不汗出为主，所以用桂枝、杏仁助麻黄以发表，表气得开则郁阳得发；越婢汤是治疗水与风合，一身悉肿的风水证，以身体肿胀汗出为主，用石膏配麻黄以清肺热，肺热清则治节行，通调水道而能运化水湿。因此，用越婢汤治溢饮，取法于大青龙汤而又不同于大青龙汤，本案身多汗而四肢无汗是辨证的着眼点。

25.桂枝甘草龙骨牡蛎汤证

心悸案

宋某，男，35岁。宋君的职业是教师，常常伏案工作至深夜，耗气伤神。忽一日突发心悸，严重时心神难定，坐立不安。舌质淡苔白，脉缓而弦，按之无力。此因过用心神，心气虚而神气不敛所致。

桂枝9克 炙甘草9克 龙骨12克 牡蛎12克三剂。

嘱其夜晚减少工作以养心神，果然药尽而安。

【解说】

宋君的病证起于过劳多虑，过劳则伤气，多虑则伤神，所以，养生之法务在起居有常，劳逸相得。桂枝甘草龙骨牡蛎汤，是张仲景用来治疗因误用烧针，损伤心阳所引起的烦躁证，用桂枝、甘草温补心阳，龙骨、牡蛎安神定志。尤其值得一提的是，桂枝、甘草二味药物，辛甘合化为阳，是张仲景用来治疗各种原因引起的心阳虚损，不能固护于上而出现心悸、胸闷等证的基本药物，临证之时，不可不知。

26.茯苓桂枝白术甘草汤证

（1）水气上冲案

陈某，女，52岁。患头晕，心悸，胸中满闷，每到夜晚则气上冲胸，诸证随上冲之势而加剧。伴有面部虚浮，目下色青，下肢轻度浮肿，小便短少不利，口虽干但不欲饮水，强饮则胃中痞闷。问其大便反而秘结不通，五六日一次，坚如羊屎。舌质淡胖，苔白滑，脉沉滑无力。此证为心脾阳气两虚，脾阳不运，则水气内停，心阳不振，则水气上乘。水气上冲，阴来搏阳，所以头晕，心悸，胸闷；水气不化，津液不能布行，则小便不利而大便反秘；水气外溢皮肤则为浮肿。治疗当以温通心阳，气化津液，降冲伐水为主。

茯苓30克 桂枝10克 白术10克 炙甘草6克

服药两剂后，气上冲胸及头晕、心悸等证得以控制。上方加肉桂3克，泽泻10克，助阳消阴，利水行津，又服两剂，口渴止，小便利而大便下。最后采用脾肾双温之法，又合用真武汤使阳回阴消，精神振奋。

（2）奔豚证案

陆某，男，42岁。因患冠心病心肌梗死而住院，经两个多月治疗，病情没有缓解。现症：心胸疼痛，心悸气短，每当心痛发作之时，自觉气上冲咽喉，便觉气息窒塞，周身出冷汗，恐怖欲死。舌淡苔白，脉弦而结。此奔豚发作，属于心阳虚衰，坐镇无权，水气上冲，闭塞胸阳。治当通阳下气，利水宁心。

茯苓18克 桂枝10克 白术6克 炙甘草6克 龙骨12克 牡蛎12克 三剂。

药后冲气平息，心神得安，但脉仍有结象，并伴有明显的畏寒肢冷。此下焦肾阳未复，水寒之势尚未平伏。上方加附子10克，生姜10克，白芍10克，又服三剂，下肢转温。但心悸，胸痛偶发，转用：茯苓12克，桂枝10克，五味子6克，肉桂3克，炙甘草6克，又服六剂后，诸症皆平。心电图检查大致正常。

（3）鼻不闻香臭案

吴某，女，50岁。患鼻塞难以呼吸，不闻香臭气味，每晚都要用“鼻眼净”滴鼻才能安然卧寐，否则，鼻道堵塞，气道不通而被憋醒。患病已7年，屡治无功。伴见头晕，胸闷，心悸，指端麻木等症，舌质淡嫩，六脉沉弱无力。证属心肺阳气虚弱，阴气用事，久而生饮。

茯苓15克 桂枝10克 白术6克 炙甘草6克 半夏10克 厚朴10克 薤白10克

此方连续服用十多剂，饮消气通，而后鼻能闻知香臭。

【解说】

李东垣曾指出：中气虚弱，清气不升，可以导致清窍不利的病变，所以他采用温补脾胃而升清阳的方法来治疗清窍不利证。但是，本案则运用苓桂术甘汤温阳化饮之法来治疗清窍不利病变。这是因为心肺阳气虚弱，寒饮内生，也往往可以产生鼻塞，呼吸不利等证，这种情况在临床上并不少见，应该引起注意。

（4）眩晕案

吴某，女，38岁。

患头晕目眩，严重时坐立不稳，经多方诊治仍无疗效。病人面色**晄**白，舌质淡苔水滑，饮食与二便基本正常。辨为水饮内停，上冒清阳，治以温化痰饮为法。

茯苓30克 桂枝12克 白术10克 泽泻15克 牛膝10克 炙甘草6克 三剂。

服药后疗效显著，眩晕明显减轻，因方药对证，嘱其继续服用，又六剂后，证情基本稳定，予泽泻汤加味善后。

【解说】

张仲景用苓桂术甘汤治疗两方面的病证。一方面是《伤寒论》所说的“心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧”。另一方面是《金匮要略·痰饮咳嗽病篇》中所说的“心下有痰饮，胸胁支满，目眩”。这两方面病证都是人体水液代谢失常，气不化水，水停于内为患，所以，又称之为“水气病”。这里所讲的“水气”概念，应该是既指有形的水饮，又包括无形的水寒之气。水指其形，寒指其气，如影之随形，不可分隔，所以往往合一而发病。水气病的发病机理，主要与心、脾、肾三脏的阳气虚衰有关。心属君火，上居胸中，能行阳令而制阴于下，如果心阳不足，坐镇无权，不能降服下焦阴气，则使寒水邪气上泛；脾为中土，有运化水湿之功，如果脾阳虚弱，不能运水制水，亦容易导致水气内生；另外，肾主水而司气化，与膀胱相表里，膀胱为州都之官，内藏津液，全赖肾阳的气化作用而能出其津液，如果肾阳不足，气化无权，不能主水于下，则津液停聚而为水邪。

水气病的最大临床特点就是“水气上冲”。由于心阳虚衰，不能坐镇于上，在下的水寒邪气乘虚上凌则发为水气上冲。水气上冲虽然与心、脾、肾三脏阳气之虚有关，但其中尤其以上焦的心阳虚不能降伏下焦阴

寒为前提。水气上冲的典型临床表现是：气从脐下，或心下部位上冲胸咽，像如豚之奔突，所以古人称之为“奔豚气”。然而气从脐下往上奔突的，则多与心肾阳虚有关；气从心下部位往上冲逆的，则多与心脾阳虚有关。

水气上冲，既是水气病的病证特点，又是水气病的病理反映过程。大凡水气上冲所经过的部位，如脐下、心下、胸中、咽喉，以至于头面，五官清窍等地，则出现胀满、悸动、憋闷，或噎塞，或咳喘，或眩晕等症状。除此之外，辨识水气病，还可以从色、舌、脉诸方面观察。望色：临床多见面色黧黑，或出现水斑（即额、颊、鼻柱、口角等处，皮里肉外，出现黑斑），舌体胖大，舌质淡嫩，舌苔多呈水滑之象；切诊：脉象多见沉弦或沉紧。

治疗水气病，主要应采用温阳化饮，利水降冲的方法，选用以茯苓、桂枝为主的一类方剂，而苓桂术甘汤则是苓桂剂的代表方。茯苓在本方中有四方面的治疗作用：一是甘淡利水以消阴；二是宁心安神以定悸；三是行肺治节之令而通利三焦；四是补益脾土以防水土上冲。桂枝的治疗作用有三方面：一是补心阳以制水；二是通阳以消阴；三是下气以降冲。茯苓、桂枝相须相使，缺一不可，如果有茯苓而无桂枝，则不能化气以行津液；如果有桂枝而无茯苓，则不能利水以伐阴邪。白术协茯苓补脾崇土以制水；炙甘草助桂枝扶心阳以降冲。本方在临床上常用于以下几方面病证，疗效较佳。

①冠心病，心肌梗死，常见胸闷疼痛，心悸头晕，短气乏力，或浮肿，小便不利，并有相当一部分患者伴有明显的气上冲证。

②老年性慢性支气管炎，肺源性心脏病，见有胸闷憋气，咳嗽或喘，痰多稀白，面目浮肿等证，如果是急性发作，喘逆倚息不得卧者，可先服小青龙汤，待症状缓解后，再服本方调理巩固。

③不是上述病证，但是有明显水气病见证时，亦用本方治疗。

又附：水气上冲案

李某，女，59岁。有冠心病史，前来门诊求取中成药。症见：心下逆满，气上冲胸，起则头眩，肌肉跳动，畏寒肢冷，大便反干，数日一次，舌黯红而脉沉弱。观其先前所服之药，皆以薤白、栝蒌、丹参、檀香等活血理气为主。劝其再服汤药，予苓桂术甘汤原方三剂。复诊时面有喜色，谓此次服药对证，疗效显著，如是原方继续服用而大见功效。

【解说】

活血化瘀方法，是目前临床治疗心脏病的常用方法之一。而“心为阳中之太阳”，心阳不足的心脏病则用苓桂术甘汤，乃是“温药和之”的

方法，两法并存不可偏废。由于本方临床运用十分广泛，所以加减方法也比较多，比如：兼心神浮越而惊悸恐怖者，加龙骨、牡蛎以潜敛之；兼痰湿内盛者，合二陈汤以化痰；兼水冒清阳而眩晕重者，加泽泻利水；兼虚阳上浮而面热，心烦者，加白薇以清虚热；兼心血不续而脉结代的合生脉饮；或肾不纳气而少气喘息的，加五味子、紫石英；兼血压偏高加牛膝；兼口舌干燥欲饮水，而舌反红绛者，加太子参、沙参和丹参；若阳虚水泛严重者，见有畏寒肢冷，下肢浮肿，大便溏泄等证，则必与真武汤合用等等。除此之外，还有几种最常用的加减法，分别附列于下。

附一：苓桂杏苡汤证

苓桂术甘汤去白术、甘草，加杏仁、苡米，名曰苓桂杏苡汤。主治水气兼挟痰湿，水湿相因为患，症见咳嗽多痰，胸满，不欲饮食，周身酸楚，头重如裹，小便不利等。曾治李某，年逾八旬，生活尚能自理。入冬以来，常觉胸满，咳嗽吐白痰，周身酸懒，不欲行动，不思肥甘之物而欲素食。舌质淡苔白腻，脉弦缓无力，即用苓桂杏苡汤治疗，六剂后诸证均明显好转，转用异功散善后。

附二：苓桂芥甘汤证

苓桂术甘汤去白术，加白芥子疏肝利气，名曰苓桂芥甘汤，主治水气兼挟肝气上逆。曾治曹某，女，43岁。胸胁发满，入夜为甚，头晕目眩，心悸气短，暖气频作，心烦易怒，来月经时，小腹作胀，面色黧黑，舌苔水滑，脉沉弦。用苓桂芥甘汤加香附，六剂后胸胁不满，暖气不作，其余各症也明显减轻。转用小剂桂枝茯苓丸作汤剂，又加香附、郁金等药调治而获痊愈。

附三：苓桂茜红汤证

苓桂术甘汤去白术、甘草，加茜草、红花，名曰苓桂茜红汤。主治水气兼挟瘀血痹阻胸中。曾治太原曹某，素有冠心病史，近来头晕，胸闷疼痛，控及后背，舌边有瘀斑，苔水滑，脉弦。乃用苓桂茜红汤，诸症平息而安。

27.茯苓桂枝甘草大枣汤证

(1) 奔豚证案

郭某，男，56岁。患奔豚证，发作时气从少腹往上冲逆，至心胸则悸烦不安，胸满憋气，呼吸不利，并见头身汗出，每天发作两三次。小便短少不利，有排尿不尽之感。舌质淡，苔水滑，脉沉弦无力。此水气下蓄，乘心脾阳虚而上冲。

茯苓30克 桂枝12克 大枣15枚 炙甘草10克

上方服用两剂，则小便畅通，奔豚气不再发作。

(2) 欲作奔豚证案

李某，男，43岁。脐下悸动，欲作奔豚，伴小腹及胃脘胀闷不舒，心悸。寸脉软，关尺之脉俱弦。此心脾阳虚，水寒之气将欲上冲之证。

茯苓30克 桂枝12克 大枣15枚 炙甘草6克 肉桂3克

三剂后冲逆之势平伏，转用真武汤加桂枝，三剂而愈。

【解说】

茯苓桂枝大枣甘草汤即苓桂术甘汤去白术而加大枣。本方临床治疗水气病中属于心脾阳虚，下焦水寒之气妄动所致的欲作奔豚或已作奔豚疗效甚佳。在此需要说明几个问题。第一个问题是为什么要去白术而加大枣？白术和大枣都具有健脾益气的作用，都可以用来治疗气冲上逆的病证。但张仲景用此二药却有所不同，治疗气从“心下”上冲者用白术，治疗气从“脐下”上冲者用大枣。这是因为气从心下上冲者，病机在于脾虚不运而使水气上冲，所以用白术健脾兼能行水；至于气从脐下上冲者，关键在于其人气水相搏，小便不利而脐下悸，所以重用茯苓至30克，桂枝至12克，则超过其他有关方剂，然利水去邪之力大犹恐津伤液脱，所以去白术而用大枣补脾胃，生津液，寓防于治，从临床上来看，是很有实践意义的。第二个问题是如何判断欲作奔豚和已发奔豚？欲作奔豚的临床特点是脐下或脐周部位悸动不安，这是病人自己能感觉得到，这就说明了水与气相搏于脐下，欲上冲而未冲的情况；已作奔豚的临床特点是病人能明显地感觉到有一股气从脐下向上冲逆，随之而产生各种证情。虽然这是两种不同的临床特点，但都可以用苓桂甘枣汤治疗。第三个问题是桂枝加桂汤和本方都可用来治疗气从脐下往上冲逆的“奔豚”证，如何进行区别？根据临床观察，苓桂甘枣汤证除有脐下悸

外，还有小便不利等证，而舌苔水滑，面色黧黑，这在辨证时是主要的区别点。

28.茯苓甘草汤证

（1）心下悸动案

陈某，男，26岁。暑夏抗旱，挑水浇地，酷日之下劳动，汗出特别多，口中干渴难忍，因而俯首水桶暴饮，当时甚觉凉爽，但不多时则感到心下胃脘部位筑筑然悸动不安，入夜亦不得安寐。经多方诊治不见功效。来诊时，令其仰卧床上，用手按其心下，悸动应手；又用手震颤上腹部，可清晰地听到胃中漉漉作响。其人小便尚利，舌苔水滑，脉弦。此证主胃中有水饮。

茯苓20克 桂枝10克 炙甘草6克 生姜汁一酒盅 二剂。

先煮前三味药，待药成后，以姜汁兑药服。服药一剂后，自觉热辣气味直抵胃中，而胃中鸣响悸动为甚。不多时，忽觉腹中疼痛欲作泻利，急忙登厕更衣，泻出水液甚多，随之而悸动明显减轻。二剂服尽则全安。

（2）头痛案

邓某，男，45岁。患有高血压病史，近日来头痛剧烈，心悸，恶心想吐，严重时伴见头身汗出湿冷。舌苔白滑，脉弦缓无力。此胃中水饮上凌，瘀阻血脉之象。

茯苓30克 桂枝10克 生姜15克 炙甘草6克 牛膝10克 红花6克 茜草6克 半夏15克 陈皮10克 三剂。

服药后血压回降，头痛止而诸症消退。

【解说】

茯苓甘草汤是由苓桂术甘汤去白术加生姜而成，所以又被称为“苓桂姜甘汤”。张仲景用本方治疗水饮停留于胃中，阻碍气机，郁遏清阳所致的“厥而心下悸”。生姜有很好的和胃散饮作用，所以常被用来治疗饮气在胃所引起的各种病证。导致水饮停留胃中的原因大致有二：一是胃阳不足，不能行散水气而致饮停，这是内因；二是短时间内多饮暴饮，使得外来之水聚于胃中而不化，这是外因。虽然内外可以相因为病，但外来之饮往往是引发疾病的主要来源。为了防止外来之饮的损伤，《伤寒论》中曾指出：“渴欲饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈”。如若不然，因渴而暴饮，就会导致胃中停水的病变，所以，《金匮要略·痰饮咳嗽病篇》指出：“凡食少饮多，水停心下，甚者则悸，微

者短气”。水饮停于胃中，最突出的临床表现就是“心下悸”，此外，水饮邪气上冒清阳，还可出现头晕头痛，胸闷短气等证，也应引起临床家的注意。

又附：胸闷案

李某，女，4岁。自春节后，出现胸闷、短气而善太息已三个多月，夜寐时不时惊惕，掌心发热而且湿润，舌质淡黯，苔滑润。询知素常口渴多饮，尤其喜凉饮。据此而辨为水饮伤中，清阳不利，治用茯苓甘草汤原方温化胃中水饮。服药三剂后明显见效，胸闷短气及夜卧惊惕等已基本消除。

29.苓桂杏甘汤证

(1) 咳喘案

某妇，65岁。咳而微喘，面目浮肿，小便不利，舌质胖嫩苔水滑，脉弦。此为有水气，水气犯肺则咳而兼喘，肺失治节之权而不能通调水道则小便不利而浮肿。治用通阳下气，利水消肿之法。

茯苓12克 桂枝10克 杏仁10克 炙甘草6克

连服五剂，小便利而诸证悉平。

(2) 喘而心悸案

燕某，男，59岁。患肺源性心脏病，住唐山市某医院治疗。喘咳逆息不能平卧，心悸，气短，面色黧黑，大便已数日未解，舌苔白腻但根部发黄，脉弦而结。证为痰热内凝，腑气不利，肺气受阻，故而喘咳。但心悸气短，面色黧黑，脉结，则为心虚挟饮。此证本虚标实，当先清化痰热以利肺，然后温阳化饮而治心。

栝蒌30克（先煎） 半夏10克 黄连6克

服两剂后，大便通畅，喘咳减轻已能平卧。转用通阳化饮苓桂剂以治其本。

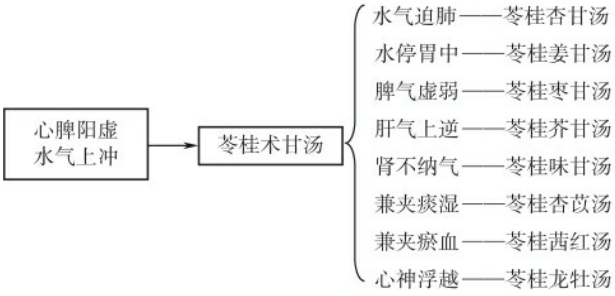
茯苓12克 桂枝10克 杏仁10克 炙甘草6克 半夏10克 五味子6克

服六剂后，喘咳止而心悸宁，遂出院调治，以善其后。

【解说】

苓桂杏甘汤由苓桂术甘汤去白术加杏仁而成，治疗水气上冲，迫使肺气不利，不能通调水道所致的小便不利，面目浮肿以及咳喘等证。

以上我们就以苓桂术甘汤为代表方的苓桂剂的证治作了简要的介绍。总的来看，苓桂剂作为治疗水气病的主体，有两个很明显的特点：一是病变以心脾阳虚为主，治疗以茯苓、桂枝为核心。二是水气为病，涉及范围很广，而与肺、肝、胃、肾、肠等脏腑也有密切的关系；虽然以水气之邪为主，但也能兼挟痰湿、瘀血等。为了能更加清楚地反映苓桂剂这一整体特点，特列下图以示归纳。



30.五苓散证

（1）癫痫案

王某，男，18岁。患癫痫病，屡用苯妥英钠等抗癫痫药物不能控制其发作。自述每次发作前感觉有一股气从小腹往上冲逆，至胃则呕，至心胸则烦乱不堪，上至头则晕厥而不知人事。少顷，其气下移而苏醒。素常小便短少，频数不利，大便正常。舌质淡嫩苔薄，脉沉滑。此水蓄膀胱，上逆而冒蔽清阳之证。《金匱要略·痰饮咳嗽病篇》说：“吐涎沫而癫眩者，此水也，五苓散主之”。

泽泻18克 茯苓12克 猪苓10克 白术10克 桂枝10克 肉桂3克 三剂。

服药后小便畅利，而后病发次数减少。方药与病证相符，而癫痫发作得以控制。

（2）阴肿案

孙某，女，43岁。会阴部位肿胀而有下坠之感，伴头晕而胀疼，口干但不欲饮，心中烦，小便不利，大便稀溏。舌质淡黯，苔薄白，脉沉。此水停下焦之证。

茯苓12克 猪苓10克 泽泻10克 桂枝6克 白术6克 牛膝10克

服药四剂后，小便得利而大便成形，会阴部肿胀消除。

（3）疝气案

陈某，男，36岁。左侧少腹疼痛控及腰部，小便短少不利，脉弦，舌苔白。此水湿之邪伤于厥阴经脉而成疝气疼痛，加味五苓散主之。

茯苓15克 泽泻10克 猪苓10克 桂枝10克 白术10克 小茴香10克 木通10克 川楝10克

服药三剂痛止。

【解说】

从药物组成上看，五苓散与苓桂术甘汤比较接近，但从组方意义及治疗重点分析，则与苓桂术甘汤有较大的差异。五苓散中用桂枝、猪苓、茯苓、泽泻发汗利水以利小便为主；白术补脾气制水气以运输水湿；桂枝辛温通阳，外能解肌，内能气化津液消阴以行水。全方以利水通阳为主，治疗重点在于水蓄膀胱，而膀胱气化不利。临床辨证以微热、消渴、小便不利等证为着眼点。

五苓散的临床运用相当广泛，本方略加变通，或与其他方剂合用，可以用来治疗多种水湿蕴郁的病证。本方加茵陈，名为“茵陈五苓散”，治疗湿邪内郁而小便不利的黄疸证；本方加寒水石、生石膏、滑石，名为“桂苓甘露饮”，治疗湿邪郁而化热的小便不利，烦热而口渴；本方去桂枝，加人参、肉桂，名为“春泽煎”，治疗高年体弱，正气不足，中气虚衰，心功能不全而小便不利者；本方加苍术、附子，名为“苍附五苓散”，治疗素体阳虚，寒湿内生，症见腰眼发凉，两足发冷，腰腿酸重，小便不利等证；本方合平胃散，名为“胃苓汤”，治疗平素喜食厚味肥甘，久而湿浊内停，而使胃脘胀满，小便不利。本方加川楝、木通、小茴香，是陈修园治疗疝气的经验方，临床证明，凡疝气而见小便不利，舌苔白滑者，用之甚佳。

叶天士曾说：“通阳不在温，而在利小便。”五苓散通阳而利小便，可谓治湿之第一方，临床凡治湿邪为病，宜多从此方着眼。

31.桂枝去桂加茯苓白术汤证

（1）低热案

刘某，女，53岁。患低热，37.5℃左右波动，持续两个多月不退。伴见胃脘胀满，项部拘急不舒，询知小便短涩不利，有排而不尽之感。舌体肥大，苔水滑，脉弦。辨为水郁阳抑之发热，用桂枝去桂加茯苓白术汤治疗。

茯苓30克 白术10克 白芍15克 生姜10克 大枣7枚 炙甘草6克

此方连服五剂后，小便畅利，发热等证皆愈。

（2）偏头痛案

金某，女，42岁。患左侧偏头痛三年多，屡治不效。伴有项强，胸脘胀满不舒，小便频数短少，大便正常。脉弦紧，舌苔水滑欲滴。

茯苓30克 白芍30克 白术10克 炙甘草10克 大枣12枚 生姜10克

服药六剂而愈。

（3）项强腹痛案

郭某，男，38岁。患头项强直不利，俯仰困难，并伴见胃脘疼痛，有诊断为颈椎病的，也有诊断为胃溃疡的，但屡治不效。脉沉弦，视其舌红而苔水滑，乃问其小便情况，告知白昼小便短少，夜间小便频多，但总有排尿不尽之感，大便偏干。辨为太阳膀胱停水不化，腑气不利，必及其经，所以项强而心下作痛。

茯苓30克 白芍15克 白术10克 炙甘草10克 生姜 10克 大枣7枚

上方共服六剂，项强变柔，小便畅利而胃脘亦舒。

【解说】

《伤寒论》第28条说：“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之”。历代医家对这一条原文的认识和理解很不一致。如清人徐大椿说：“凡方中加减法，皆佐使之药，若去其君药，则另立方名。今去桂枝，而仍以桂枝为名，所不解也”。钱天来也说：“治之以桂枝去桂加茯苓白术汤，未详其义，恐后人传写之误，未可知也。即或用之，恐亦未能必效也”。而《医宗金鉴》的作者吴谦更是直接提出：去桂枝当是去芍药之误。

那么，到底应该怎样认识这一问题呢？首先，应该回到桂枝汤及其加减变化的特点上。桂枝汤的最大特点就是滋阴和阳，实现这一特点的药物配伍是桂枝配芍药。桂枝和芍药，一阳一阴，在临床上具有二分法的意义。比如既有桂枝加桂汤，就有桂枝加芍药汤，那么，有桂枝去芍药汤，就应该有桂枝去桂汤，这样一来，使得阴阳相互对应，符合疾病变化及其治疗的客观规律，从这一点分析，桂枝汤而去桂这种情况确实是存在的。其次，从桂枝去桂加茯苓白术汤的药物组成来看，不妨将它与苓桂术甘汤对应起来，以便更加清楚地认识去桂的意义。《伤寒论》中，仲景用真武汤扶阳利水，就有猪苓汤育阴利水以对应之，这是因为人体水液代谢的失常关系到阴和阳的两个方面。那么，仲景举苓桂术甘汤通阳利水，就应该有与之相应的和阴利水的方剂。这个问题的答案就在去桂加苓术汤之中。该方的药物组成是：茯苓、芍药、白术、炙甘草、生姜和大枣。从上述药物看，不难发现，苓芍术甘四味药物正好与苓桂术甘四味药物有桂枝与芍药阴阳对应的特点，因此，不妨暂时将其称为“苓芍术甘汤”。“苓芍术甘汤”中用芍药，一方面能滋阴和阴，另一方面与茯苓相配，则又有去水气，利小便的作用。所以，“苓芍术甘汤”能够和阴利水，正好与苓桂术甘汤通阳利水构成阴阳对应的关系。而其中又有生姜、大枣，则犹如苓桂术甘汤有苓桂枣甘汤、苓桂姜甘汤之变通。既然如此，仲景为什么不直接称之为“苓芍术甘汤”，反而要把它称为“桂枝去桂加茯苓白术汤”？这里面可能有两个原因。其一，仲景文笔，条文排列往往有前后对举之法，第21条既然列出桂枝去芍药汤，所以第28条又指出桂枝汤还有去桂这一方法，使人对照看待，以见“胸满”与“心下满微痛”两证有上下之不同；其二，仲景恐后人在“头项强痛，翕翕发热”上抓住桂枝不放，而过分执意桂枝的解表作用，因而强调了本方必须是去桂枝而留芍药。所以，读仲景书一定要能从隐藏之处求出其奥义所在。

临床运用桂枝去桂加茯苓白术汤，辨证的关键是在“小便不利”。小便不利是膀胱气化失常，水邪内停的反映。水邪内停于膀胱，可以郁遏其经脉之中阳气的疏达，阳气受郁，经脉不利，则可见到翕翕发热，头项强痛等外证，所以看似表证而实非表证；水邪凝结，郁阻气机，使得里气不和，则可见到心下满微痛等里证，似里实并非里实证，所以汗、下之法都不能适用。本证的病机过程是：小便不利—水郁膀胱—外气郁遏，里气阻结。

既然小便不利是辨证的关键，为什么不用五苓散以利小便？这个问题清人唐容川已经说得很清楚了。他说：“五苓散是太阳之气不外达，故用桂枝以宣太阳之气，气外达则水自下行，而小便利矣。此方（桂枝

去桂加茯苓白术汤）是太阳之水不下行，故去桂枝，重加苓术以行太阳之水，水下行则气自外达，而头痛发热等证，自然解散。无汗者，以微汗而愈矣，然则五苓散重在桂枝以发汗，发汗即所以利水也；此方重在苓术以利水，利水即所以发汗也。实知水能化气，气能行水之故”。

32.桃核承气汤证

惊狂案

杜某，女，18岁。因遭受惊吓而精神失常，或哭或笑，惊狂不安，伴见少腹疼痛，月经衍期不至。舌质紫黯，脉弦滑。此乃情志所伤，气机逆行，血瘀神乱。桃核承气汤主之。

桃仁12克 桂枝9克 大黄9克 炙甘草6克 柴胡12克 丹皮9克 赤芍9克 水蛭9克 二剂。

药后经水下行，少腹痛止，精神随之而安。

【解说】

在《伤寒论》中，张仲景用桃核承气汤治疗“热结膀胱”证，以“少腹急结，其人如狂”为主要临床表现。本证的病机关键在于下焦蓄血，瘀血与邪热相结。从临床实际情况来看，多与妇女经血瘀阻有关，如瘀热闭经，少腹硬痛而心情烦躁或如狂者，服用本方多有疗效。另外，产后恶露不下，瘀血内阻而见喘胀欲死，或精神狂妄者，亦可使用本方。本方还可与桂枝茯苓丸交替使用，治疗妇女癥瘕痞结；若与大柴胡汤合用，则应用范围更广，凡是胸胁肋疼痛，以两侧为主，每遇阴雨寒冷而痛势加剧，或有跌仆损伤病史者，是为瘀血久停于内，无论其部位在上在下，皆能获效。

临床运用桃核承气汤，还要注意以下几个问题。一是瘀血内停，血络受阻，心脉失养，往往见到精神及情志方面的异常，轻者烦躁、善忘，重者如狂、发狂。所以《内经》说：“血在上善忘，血在下如狂”。这是下焦蓄血的一个比较明显的证候特点。二是从致病原因上看，虽然瘀血作为其主要的病因，但是骤然受到惊吓，也往往是发生本病的一个重要诱因。三是本方有较强的泄热逐瘀作用，运用时一定要以患者的体质壮实为前提，如果体质虚弱，则不能轻率使用。四是在服药时间上，一般以空腹时为佳，因为病位在下焦，而桃核承气汤又是攻下瘀血的方剂，所以，空腹服药有利于攻逐瘀热。张仲景说：“先食温服”，也就是这个意思。

33.抵当汤证

瘀血目障案

刘某，女，31岁。产后受风引起目疼，以致视力逐渐下降已二年余。病变先从右眼开始，视力从1.2降至0.1。经眼底检查，发现眼底水肿，黄斑区呈棕黑色变化，被诊断为“中心性视网膜炎”，经过治疗，右眼视力恢复到1.0，但左眼视力又从1.5下降到0.1。服用中成药石斛夜光丸后，视力有所上升，左眼达0.8，右眼至1.2。但患者常觉后背疼痛，右侧少腹亦疼，每次遇到月经期则两腿发胀，腰腹俱痛，而且精神紧张，惊怖不安，少寐善忘。舌质黯绛，舌边有瘀斑，脉弦滑。根据上述脉证，辨为下焦蓄血，气滞血瘀，瘀浊上扰，乃用逐瘀活血之法治疗。

大黄9克 桃仁15克 虻虫6克 水蛭6克 丹皮9克 白芍9克

服药后约六七小时，出现后脑部跳动性疼痛，同时小腹疼痛难忍，随即大便泻下颇多，小便赤如血汁，而后诸痛迅速减轻，顿觉周身轻松，头目清晰。此后转用血府逐瘀汤加决明子、茺蔚子，又服六剂后，视力恢复如常人。经眼科检查，黄斑区棕黑色病变已基本消失。

【解说】

本案辨证有两个着眼点：一是抓住少腹疼痛，经期加剧的瘀血证；二是出现精神紧张，惊怖不安等精神情志上的变化，所以辨为下焦蓄血。产后外感，而血结于下，瘀血在内则新血不生。肝主藏血而开窍于目，肝受血则目能视。今新血不生，肝血不能养目，因而视力下降。服用抵当汤后，瘀血去而新血生，目得肝血之养，故能提高视力，达到治疗目的。

抵当汤在临床上还可用治于女性精神分裂症，伴有经血瘀阻者多能取效，其作用机理与桃核承气汤大致相同。抵当汤与桃核承气汤二方，针对下焦蓄血的病机，在适应证上均包括下焦瘀血证与精神情志失常两个方面，同样多运用于妇女，如何将其区分开来是很困难的。尤在泾曾经说：“抵当汤中，水蛭、虻虫食血去瘀之力倍于芒硝，而又无桂枝、甘草之甘缓，视桃核承气汤为较峻矣。盖血自下者，其血易动，故宜缓剂，以去未尽之邪；瘀热在里者，其血难动，故须峻药，以破固结之势也”。这段话为二方之峻缓作了区别，但读后仍有临证难用之感。根据我们的经验，凡下焦蓄血而热大于瘀，其人大便秘结，干燥难下的，则用桃核承气汤；如果瘀大于热，大便虽硬，但排解反而容易，大便色黑

如煤，病人善忘或发狂的，则用抵当汤。此外，如果先用抵当汤已经取效，恐多服伤及正气，也可改用桃核承气汤治疗。

34. 梔子豉汤证

虚烦案

王某，男，28岁。病证始于外感，数日后，心中烦郁之极，整日坐卧不安，懊^怏难眠，辗转反侧。家人走近与其交谈则挥手斥去，喜独居而寡言，全家人为之惶惶不安。询知大便不秘，但小便色黄，脉数而舌苔薄黄。这种情况张仲景称之为“虚烦”，治当清宣郁火。

生山梔9克 淡豆豉9克

服药后不久，心胸烦乱反而更加严重，继而气机涌逆而作呕吐，伴随全身汗出。家人唯恐服药有误，派人前来询问。被告知服药后得吐而汗出，乃是气机调畅，郁热得以宣透的好现象，其病将愈，不用惊慌。果如所言。

【解说】

梔子豉汤以善治虚烦证而著称。“虚烦”是一种证候名称，其病理特点为火热邪气蕴郁，而使胸膈气机阻塞不利。“虚”是指无形火热邪气，“烦”是指心烦主证。“虚烦”并非一般的心烦，仲景称之为“心中懊^怏”，形容其心中烦乱，难以名状，而又不能制止，无可奈何，往往使人坐卧不安。由于是火郁气结，所以有时可兼见“胸中窒”，“心中结痛”或“心烦腹满”等气血郁滞不利的特点，可统称之为“火郁证”。

火当清之，郁当发之，所以用梔子豉汤清宣郁火。梔子苦寒清热，但因其体轻而上行，清中有宣，与芩、连苦降直折不同。凡火热郁而烦者，非梔子不能清，所以丹梔逍遥散及越鞠丸的火郁都用梔子而不用其他。豆豉气轻味薄，既能宣热透表，又可和降胃气，宣中有降，善开火郁，同梔子合用治疗火郁虚烦甚为合拍。

服用梔子豉汤后有“得吐”的反应，这并不是药物本身能催吐，而是火郁作解的一种表现形式。因为火热郁于胸膈，气机被困，服药后火郁得以宣发，气机得以伸展，正气拒邪外出，所以会发生呕吐的情况。临床所见，凡是郁烦证情越严重，服药后得吐的机会也就越多。如果郁烦并不严重，那么服药后也有不吐而愈，不可绝对而论。

35. 栀子厚朴汤证

（1）虚烦腹满案一

董某，女，37岁。症见：心中懊^怏，不能自控，昼轻夜重，甚则奔出野外空旷之处，方觉稍安，并有脘腹胀满如物阻塞之感，小便色黄，但大便不秘，舌尖红绛，舌根有腻苔，脉弦数。此属心火内盛而有下移之势，然未与肠中糟粕相结。

生山栀9克 枳实9克 厚朴9克

服药一剂而愈。

【解说】

本案的辨证要点在于大便不秘。症见心烦而腹胀满，已有阳明胃肠腑气不利之势，所以仍为火郁虚烦证。

（2）虚烦腹满案二

刘某，男，36岁。心中懊^怏，卧起不安，胸中窒闷，脘腹胀满。舌尖红而苔腻，脉弦。辨为气火交郁心胸之证。

生山栀9克 枳实9克 厚朴9克 淡豆豉9克

二剂而愈。

【解说】

本案与上一案相似，因为心中懊^怏，胸中窒闷，所以用栀子豉汤宣郁；病位下及于腹，脘腹胀满，则取枳实、厚朴以利气结。

栀子厚朴汤具有清宣郁热，利气消满的作用。它既可以被看做是小承气汤的变方，即由小承气汤去大黄加栀子而成；亦可看成是栀子豉汤与小承气汤合方的化裁。把它们作一下动态观察，就不难发现其间的关系与变化。

栀子豉汤 —— 火郁胸膈，气机不利
↓
(栀子、豆豉)

栀子厚朴汤 —— 火郁胸膈，迫及脘腹
↓
(栀子、厚朴、枳实)

小承气汤 —— 热入胃肠，腑实已成
(大黄、厚朴、枳实)

36.大陷胸汤证

大结胸证案

李某，女，15岁。病起于外感，高热，39.5℃，头痛，肢体酸楚。至五六日后，突发上腹部疼痛，午后发热更甚，经某医院诊断为急性腹膜炎，准备收入住院治疗。其父考虑到经济比较困难，转而求治于中医。切脉弦紧有力，舌质红绛而苔腻，皮肤亢热，腹部板硬疼痛拒按，大便已七日未解，小便短赤，时发谵语。此为邪热内陷，与水饮相互凝结而成结胸证，宜急下之。

大黄6克 芒硝6克 甘遂末1克（另包） 冬瓜仁15克 苡米15克 桃仁9克 滑石9克 芦根15克

先煎大黄等物，汤成去滓，纳入芒硝微沸，再下甘遂末和匀，温分二次服下。初服后约一小时，大便作泻，但不畅快；二服后不久，大便与水齐下，随之脘腹疼痛顿释，发热渐退。嘱令糜粥调养而愈。

【解说】

大陷胸汤是治疗大结胸证的主方，泄热逐水的力量较为峻猛，临床施用时要注意药量宜轻，中病即止。尤其是甘遂一物，性猛有毒，难溶于水，不但要注意其用量，而且要用粉末冲服，才能发挥疗效。临床辨大结胸证，要抓住以下特征：一是脉沉紧有力；二是胸腹部位硬满疼痛，按之硬如石。因为其病位比较广泛，“从心下至少腹硬满而痛”，所以称之为大结胸。从诊断角度看，仲景所谓的“按之石硬”或“不可近”，一方面说明了病证的严重程度；另一方面则提示医家，凡临证诊疾，有腹部疾患者必须进行腹诊，亲手切按，以别病情。比如大结胸证与阳明腑实证，二者均可出现高热，脘腹疼痛拒按以及大便燥结不下等症状，但如果在腹诊中发现按其腹而石硬，就属结胸证，否则便是阳明腑实证。

37.大陷胸丸证

结胸证案

罗某，男，45岁。罗君素有茶癖，每日把壶长饮，习以为常。其人身体肥硕，面目光亮，常以身健而自豪。不料冬季感受风寒，自服青宁丸与救苦丹后，不但无效，反而转为胸中硬痛，呼吸不利，项背拘急，俯仰困难。脉弦有力，舌苔白腻而厚。此为伏饮久居于胸膈之间，而风寒邪气又化热入里，热与水相结于上而成结胸。

大黄6克 芒硝6克 葶苈子9克 杏仁9克 甘遂末1克（冲服）

用水二碗，蜂蜜半碗，煎成半碗，纳入甘遂末。服一剂后，大便泻下2次，胸中顿爽，再服一剂，泻下4次，邪气尽出而病愈。

【解说】

大陷胸丸由大陷胸汤加葶苈子、杏仁，和蜜为丸而成，用以治疗结胸证病位偏上，邪气结在胸肺之高位，往往可见到胸胁硬满疼痛，咳喘气急等症。由于邪结较重，非峻猛之药不能攻逐于下；但又由于病位偏高，不能用急剂一下而尽，所以变汤为丸，变峻药以缓用。本案结胸证已具，若制丸药，恐病情急迫，延误治疗；若用汤剂，又与仲景法相违，所以师仲景之法，重用白蜜半碗，取其甘缓之性，使药力留恋于上焦，不致有下之过急而伤正留邪之弊。

仲景用蜜很有讲究，但归纳起来有三方面作用。一是取其甘缓之性，变峻药为缓剂，以汤为丸，适用于两种情况，一种情况是病位偏上，非急剂一下能尽者，如大陷胸丸证；另一种情况是病者体质虚弱，不耐峻药攻伐者，如麻子仁丸证。二是取蜜之甘味，甘能解毒，与毒药相配，可以监制其毒性，如《金匮要略》治疗寒湿历节疼痛的乌头汤及治疗寒疝腹痛的大乌头煎等。三是取蜜之甘润，有滑利滋燥的作用，运用于胃肠津燥失润引起的大便秘结，如蜜煎导方。

38.小陷胸汤证

小结胸证案

孙某，女，58岁。胃脘疼痛，按之加甚，且心下部位有一包块外鼓，大如鸡蛋，按之濡软而不硬。饮食正常，但大便不爽，舌质红苔黄，脉弦滑。《伤寒论》说：“小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之”。

糖栝蒌30克 黄连9克 半夏9克

服药二剂后，大便泻下黄涎许多，尔后胃痛止而包块消。

【解说】

小结胸证是由于痰热邪气凝聚于胃中，阻塞气机所引起。“正在心下，按之则痛”是本证的诊断依据。由此可见，大小结胸证的主要区别是在于病变范围的大小不同，也正是由于病位大小不同，所以要采用不同的方药治疗。

39.大黄黄连泻心汤证

(1) 鼻衄案

孙某，男，62岁。经常性鼻衄，达6年之久。近日鼻衄又犯，出血量较多，伴见心烦不眠，心下痞满，小便色黄，大便秘结，舌质发紫，舌尖红赤，脉弦数。此心胃火炽，上犯阳络，当泻火气以安血络。

大黄6克 黄连6克 黄芩6克

用沸开水泡渍，代茶饮服，一剂而愈。

(2) 齿衄案

刘某，女，30岁。齿衄半个多月，心烦，夜寐多噩梦，小便黄赤。舌质红，苔薄黄，脉滑。以泻心火为先。

大黄6克 黄连6克 黄芩6克 二剂。

服药后小便黄色加深而味浓，随之衄血明显减少。此热从小便而去，改用清胃滋阴之法。

生石膏15克 知母9克 竹叶10克 粳米10克 玄参12克 生地10克 龙骨10克 牡蛎10克 炙甘草6克

四剂后，诸证皆消。

【解说】

大黄黄连泻心汤是治疗火热邪气痞结于心下而致“火热痞”的一张名方。仲景用“心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之”共二十余字，就把“火热痞”的病机、病位、病性、主要脉证、治则与方药概括无遗。但是，临床辨证时，仅仅据此还是很不够的，往往需要参考一些其他症状，如火热邪气上扰，多见心烦，或衄血、吐血、咳血等；火热邪气迫于小肠则小便黄赤；火热痞塞心下，影响胃肠气机不利，可见大便秘结或大便不爽。此外，舌质红绛，苔黄等也常可见到。如果能综合多方面的火邪表现，结合主证主脉，则可准确无误地作出判断。

从上面两个案例可以看出，本方对于火热邪气引起的出血治疗效果是很好的，唐容川在《血证论》中治疗血病的第一张方子就是此方。但是，唐容川使用的是煎煮方法，与《伤寒论》的沸水泡渍法不同。《伤寒论》要求“以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服”。这种方法的主要目的是取药物寒凉之气以清中焦无形之邪热，而不取其苦泄之味以

防直走胃肠。唐容川用煎煮法，是从《金匱要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病篇》中的“泻心汤”而来。泻心汤的药物组成及剂量与大大黄黄连泻心汤都一样，但仲景用煎煮方法，要求“顿服”，来治疗由于“心气不足”所致的吐血、衄血，目的在于取其味厚力大而清泄血分之热。所以，虽然组成的药物相同，但煎服法不同，则其效应也各不相同。

（3）牙痛案

吕某，男，54岁。与妻子争吵之后，火气上攻，牙痛腮肿，吟痛之声闻于房外。视其牙龈红肿，舌质红而苔黄，脉弦大有力。询知大便已二天未解。

大黄9克 黄连9克 黄芩9克

沸水泡服，一剂后大便日泄4次，牙痛立释。

（4）惊狂案

某司机患精神分裂症，十多天昼夜不眠，惊惕烦躁，怒目视人。病从气恼而起，气火充斥三焦，大便已六日未解，口中臭秽。舌苔黄厚，脉洪大。

服大大黄黄连泻心汤一剂，平平无奇；又服一剂后腹痛欲泻；待三剂服尽后，大便泻下较多，烦躁虽有减轻但仍处亢奋状态。于是增加大大黄剂量至15克，药后大便畅泻，夹黏滞物甚多，顿时便觉神疲思睡。卧于床上熟睡二天，醒后神志清爽，已复常态。

【解说】

大大黄黄连泻心汤，由于组方用大大黄、黄连、黄芩三味药物，所以又俗称为三黄泻心汤。本方虽然见于《伤寒论》中，但很可能由伊尹所创制。在医学史上，伊尹是中医最早的方剂学著作《汤液经》的作者，所以后世医家将本方称为“伊尹三黄泻心汤”。从文献记载来看，最早用本方治疗疾病的医家是西汉的淳于意，用其治疗中下俱热的“涌疝”证，这在《史记》中有详细的描述。书中将此方称为“火齐汤”（“齐”字通“剂”），因而，三黄泻心汤很可能就是专门治疗火热病证的火剂门的主方。此方传至东汉末年，被张仲景收入《伤寒杂病论》之中。到了宋朝，《和剂局方》明确指出了本方具有泻三焦实热的功效，是火剂中的代表方，可以治疗：“丈夫妇人，三焦积热之上焦有热，攻冲眼目赤肿，头项肿痛，口舌生疮；中焦有热，心膈烦躁，不美饮食；下焦有热，小便赤涩，大便秘结。五脏俱热，即生瘡疔疮痍，及治五般痔疾，粪门肿痛，或下鲜血，小儿积热”。所以，现在临床上常用来治疗火气内盛，上攻外达所引起的各种火热病证。

（5）脱发案

余某，男，42岁。患脂溢性脱发，每日晨起枕头旁落发成片，用梳子梳头时头发脱落更多，头顶部毛发稀疏见秃，头皮瘙痒难忍，以手指揩而嗅之，有一股难闻的臭味。舌质红绛，脉数。辨为心火上炎，血不荣发。

大黄6克 黄连6克 黄芩6克 三剂。

服药后小便色黄如柏汁，大便泻利，热从二便而去，从此头皮痒止而发不再落。

【解说】

发为血之余，而心主于血。心火内盛则血热，血热则不能荣于毛发，发根不固所以脱落。用三黄泻心汤泻心火而凉血，所以能坚固毛发，这也是不治而治的一种体现。

40.附子泻心汤证

上热下寒案

宋某，男，48岁。患腰以上汗出而心烦，但腰以下无汗而发凉。伴遗精，阴部发冷，阴茎回缩，大便稀溏，每日一次。舌质黯红，脉沉滑。此属阴阳不和，上下水火不相交济，治宜清上温下，交通心肾阴阳水火。

制附子10克（水煎煮） 大黄 黄连 黄芩各6克（沸水泡渍）

上药和汁兑服，二剂。

服药后大便每日二三次，但不稀溏，下肢已由凉转温，汗出心烦止，梦遗阴缩消，只有阴部仍然有凉冷的感觉。舌边尖红，脉沉。这是属于火热邪气已清，但阳气尚未遍达周身之象，再投以四逆散原方三剂而愈。

【解说】

本案临床表现寒热错杂，热为真热，寒亦是真寒，临床上辨证治疗均比较困难。一般来说，上焦郁热极容易导致下寒，这是因为人体内的阴阳是处在一个相对平衡的状态，如果在上的阳气被郁而不能下达，则必然导致下焦的阳气不足而生内寒。所以用附子泻心汤，专煎附子以温下寒，另渍三黄以清上热，这样一来，寒热之药异其气而生熟之品异其性，药虽同行而功则各奏，使阴阳调和，水火交济，则诸证自愈。

附子泻心汤由大黄黄连泻心汤加炮附子而成，《伤寒论》中用来治疗“心下痞，而复恶寒，汗出者”，其病机特点是火热邪气内盛而人体真阳又虚。从表面看来，这是一种不相协调的矛盾对立，阳盛则热，阳虚则寒，为什么阳虚能与热邪同存于一体之中？如果从上下水火阴阳既济系统来看，中焦气机不能斡旋于上下，固然能产生上热下寒的格局。但是，如果从阳气与邪火的关系上来理解附子泻心汤证，似乎更能触及病变的本质。《素问·阴阳应象大论》说：“壮火之气衰，少火之气壮。壮火食气，气食少火；壮火散气，少火生气”。这段话为我们理解邪气与阳气的关系提供了理论依据。“少火”（即生命活动之火）是周身阳气产生的根源，是维持人体正常生理活动的基本保证，所以说“少火生气”。而“壮火”（即“邪火”）则是“少火”的克星，它不但能“食气”，而且能“散气”。在邪火内盛的病理情况下，如果它不断地蚕食人体的“少火”，就

能逐渐导致阳气虚衰。阳愈衰则火愈盛，火愈盛则阳愈衰，形成了一个不良的循环体，而在这个循环体中，邪火旺盛是最为关键的因素。所以，如果要打破这个循环体，恢复人体的阳气，单用扶阳的方法显然是达不到目的的，只有在消除邪火的同时，采用温补阳气的方法，双管齐下，才能收到良好的效果。也就是说，只有在“壮火之气衰”的前提下，才能使“少火之气壮”，这也正是附子泻心汤一方面用三黄清热泻火，另一方面用附子温补真阳的治疗主导思想。用这种观点来认识附子泻心汤证的病机形成原理以及附子泻心汤的组方原则，对于在临床上更好地把握本方的运用无疑是有益的。

又附治验二则：

案一：

佟某，女，26岁。患大便干结，数日一次，腹不满，牙床肿痛，口腔溃烂，口渴欲饮，小便黄赤。至午后日暮之时则头面烘热而赤，此证每月一发，多在月经来潮之前，病已一年。始以为胃肠燥热，欲投以调胃承气汤。待视其舌，舌质淡嫩有齿痕，苔白润，脉沉。舌脉与证不合，分明有阳虚之征，于是又仔细询问，方知平素形寒肢冷，汗出恶风，且心下痞，月经提前，量少而色黯，伴腹痛。此属上热下寒证。

制附子12克（水煎煮） 大黄 黄连 黄芩各6克（沸水泡渍）

和汁兑服，三剂。

服药后牙痛、口渴、汗出、心下痞等证均消，大便转常。按往常月经应提前而至，但此次没有提前。上方加附子为15克，又服三剂后，月经按期而至。

案二：

李某，男，30岁。素有胃病，胃脘痞胀，胃中嘈杂如火烧灼，心烦不寐，口腔内黏膜及舌体溃烂，全是一派心胃火热之象。舌质反而淡嫩有齿痕，苔薄白。再询其症，尚有周身乏力，时时畏寒，精神不振，性欲淡漠，纳谷不香，大便稀溏等。切其脉弦而滑。证有寒热，俱非虚假，当以清火温阳之法治疗。

制附子10克（另包单煎） 大黄 黄连 黄芩各6克（沸水泡渍）

和汁兑服，六剂。

药后胃脘痞胀及烧灼感均消，口疮愈合。但仍畏寒，大便每日二三次，续上方加大附子剂量为15克，又服三剂后，精神大振，体力增加，大便转常，诸症随之而安。

41.半夏泻心汤证

痰气痞案

张某，男，36岁。平素嗜好饮酒，常饮又多饮，日久之后，酒湿内伤，脾胃失运，中气不和，痰从中生，影响中焦气机升降失调，而成心下痞满之证。伴见恶心呕吐，大便稀溏，每日三四次。虽经多方治疗却难以收功。舌质红，苔白，脉弦滑，此属痰气交阻而成痞，治宜半夏泻心汤。

半夏12克 干姜6克 黄连6克 黄芩6克 党参9克 大枣7枚 炙甘草9克

服一剂，大便泻出白色黏液甚多，呕恶大减。再一剂，痞、利俱减。四剂尽而病愈。

【解说】

本案辨证时抓住心下痞而确定为泻心汤证；根据恶心呕吐及有嗜酒酿痰的病史而确立为痰气痞，所以服用半夏泻心汤后从大便泻出许多白色痰涎而愈。可见古人所谓半夏泻心汤治疗“痰气痞”这一说法并非虚妄。

“心下痞”是临床常见的一种病证，是指病人感到心下（相当于胃之上脘）部位有一种痞塞不通的不适感，医生采用触按的方法时，一般没有触痛或按痛感。所以，这与结胸证的“心下硬满，按之则痛”或“从心下至少腹硬满疼痛不可按者”有明显的区别。

因为病位在“心下”，处于中州，为上下气机升降的交通要道，任何原因，只要能导致中焦气机升降失常而痞塞于心下，都能产生心下痞。所以，从病机上说，心下痞属于无形之气机痞塞于中焦，与有形实邪凝结于胸中而导致的结胸证截然不同。《伤寒论》第151条说：“按之自濡，但气痞耳”，指出了心下痞的证候特点及病机关键。尽管病人自我感觉到心下堵塞，痞闷难忍，但医生按之却濡软而不坚硬疼痛，其主要机理是内无有形之实邪。根据临床所见，心下痞的种种表现，一般来说，心下痞的病人腹部总是柔软的，虽然个别病人亦会有按之疼痛的感觉，但决不像结胸证那样按之石硬，痛不可近。极少数病人有时会在心下部位鼓起一小包，按之则消，抬手又起，这叫做气包，仍属于心下痞范畴，在临床上均需加以注意。另外需要说明的是，“心下痞”是一个医学术语，病人在叙述症状时往往诉说为胃脘堵塞，如有物内阻，严重者

只能端坐而不能俯身。正确地理解病人的自我感觉，对于准确辨证是很有好处的。

脾胃虚弱，气机升降失常是形成心下痞的发病基础，脾气不升则寒从内生，胃气不降则热从内起，这样，又进一步导致了寒热之气错杂于中焦，所以，这一类心下痞又往往被称为“寒热错杂痞”。半夏泻心汤是治疗寒热错杂痞的代表方，本方集寒热补消之药于一体，能清上温下，辛升苦降，目的在于调和脾胃功能，恢复气机之升降以消痞塞。本方由于以半夏为主，具有化痰和胃降逆之功，所以针对“痰气痞”而设立。痰气内阻，容易引起胃气上逆而发生恶心，呕吐或呃逆等证，所以本方临床辨证的特点是以胃气上逆为主。至于内挟水饮的“饮气痞”，以及客气上逆的“客气痞”，则分别用生姜泻心汤及甘草泻心汤治疗。

又附：胃痛案

路某，女，27岁。有胃病史二年多，近来胃痛频发，心下痞满，按之濡软，恶心，不欲食，大便失调而肠鸣，舌体胖嫩，苔白，脉弦。疏以半夏泻心汤原方，三剂后胃痛止，心下痞消，恶心减，肠鸣失。但食欲仍少，续服上方三剂而安。

42.生姜泻心汤证

(1) 水气痞案一

苏某，女，28岁。自1982年生育后得心下痞证，至今已4年。心下痞而鸣响如雷，伴腹胀，小便不利，干呕不渴，常有低热，大便正常。他医曾用苓桂剂、柴胡剂及香砂六君子汤等方药治疗皆无寸功。舌质红苔薄腻，脉弦。此属水气凝滞于中，脾胃气机失和。

生姜12克 干姜3克 黄连6克 黄芩6克 党参10克 茯苓15克 半夏10克 炙甘草6克 大枣10枚 五剂。

服药后诸证均有明显减轻，上方加竹茹、陈皮，续服六剂，诸证皆消，数年顽疾告愈。

(2) 水气痞案二

丁某，男，47岁。患心下痞满，时而隆起一软包如鸡蛋大小，按之而痛。两胁下鸣响不适，暖气频作，口苦纳减，并见面目浮肿，小便不利，大便不成形，每日三四次。舌苔白厚，脉沉弦滑。证属脾胃不和，寒热之气痞塞于中，兼挟胁下有饮气。

生姜12克 干姜3克 黄连4.5克 黄芩4.5克 党参9克 茯苓18克 半夏9克 炙甘草6克 大枣12枚

仅服两剂则诸证悉减，心下隆起之包块平消未作，小便利而饮食增。上方又服六剂而安。

(3) 呃逆案

郭某，男，46岁。患呃逆证八个多月，呃逆频作，顽固不休，以致不能坚持工作。曾服丁香柿蒂汤、旋覆代赭汤及香砂六君子汤等无效。神疲乏力，大便稀溏，每日一二次，脉沉弦无力，舌苔润滑。上有呃逆之气，下有泻利之情，此必先病其中，脾胃升降失司。用手按其心下，告知有堵塞之感，当按心下痞证治疗。

生姜12克 干姜3克 半夏12克 黄连6克 黄芩6克 党参10克 炙甘草6克 大枣7枚 刀豆子10克

连服六剂，呃逆不作，心下痞与便溏均消，从此病愈。

(4) 失眠案

马某，女，50岁。患失眠证，每夜只能入睡二三小时，而且乱梦纷

纭，白昼则头晕神疲。舌苔滑腻，脉弦滑。初诊用温胆汤不效，再诊时，知其大便稀溏，每日二三次，伴心下胀闷不舒，时有暖气，由此而知病根在于脾胃不和。张景岳曾指出：“今人有过于饱食，或病胀满者，卧必不安，此皆胃气不和之故”。

生姜12克 干姜3克 半夏10克 黄连6克 黄芩6克 党参10克 炙甘草10克 大枣7枚

服药六剂后，夜寐稍安，心下痞减，又服六剂，夜寐基本恢复正常，大便成形，饮食有味，患者称谢告愈。

【解说】

生姜泻心汤即半夏泻心汤加生姜并减少干姜的用量而成，其组方原则亦属辛升苦降甘调之法。但本方重用生姜，加强了消水散饮的作用，所以治疗重点在于胃中不和，而挟水饮，在《伤寒论》中被称为“胃中不和……胁下有水气”。“胁下有水气”，一方面指出了本证的病机与水气有关，另一方面说明水气可以停留于胁下，临床可见到胁下胀满或疼痛等证。此外，水气的临床表现还有小便不利，下肢浮肿等。所以，临床上凡见有心下痞，暖气，下利，腹中鸣响，胁下疼痛，或下肢浮肿，小便不利者，服用本方多有良好效果。如果水气比较明显，还可在方中加入茯苓，以增强健脾利水的作用，疗效更佳。

43.甘草泻心汤证

狐惑病案

刘某，女，32岁。病变及于上中下三部，上则口腔颊部黏膜经常溃疡，糜烂疼痛难愈；中则心下痞满，饮食乏味；下则前阴黏膜溃破，疼痛瘙痒难忍。小便自可，大便成形但每日两次。此属脾虚不运，气痞于中，湿气下流又成**蠱**毒之害。

炙甘草12克 干姜9克 黄连6克 黄芩9克 党参9克 半夏10克 大枣7枚
此方共服十余剂而诸证逐渐得愈。

【解说】

甘草泻心汤的药物组成与半夏泻心汤同，但重用炙甘草为主药。重用炙甘草有两个意义：一方面能补中益气，加强补益脾胃的作用；另一方面能甘温除热。张仲景用甘草泻心汤治疗两种病变。其一，《金匮要略·百合狐惑阴阳毒病篇》中用本方治疗狐惑病。狐惑病的特点是上下溃烂，“蚀于喉为惑”，是指咽喉糜烂，声音嘶哑；“蚀于阴为狐”，是指前后二阴腐蚀溃烂。上下之变，必从中焦求之。因为中焦脾胃是上下水火之道，所以，善治者，调其中焦以治上下，这就是本案用甘草泻心汤取效的道理。但作为半夏泻心汤的变方，甘草泻心汤治疗的第二种病变是脾胃虚弱而内生虚热的心下痞证。这种心下痞往往伴有心烦不安，胃中嘈杂等虚热病证，以此作为与其他两个泻心汤的鉴别。

由此可见，仲景设立以半夏泻心汤为首的三个泻心汤方，实际上为内科治疗胃病开辟了一条途径。临床所见各种胃炎，胃肠炎以及溃疡病，若属单纯胃寒或胃热均不难治，若遇寒热错杂则较为困难。但只要熟悉三个泻心汤的不同特点而善用之，则随手拈来，有方可施。

又附：心下痞案

郝某，女，70岁。患心下痞而胃中嘈杂已四、五年，屡经中西医治疗而不效。伴口苦，大便数日一次，舌质淡红，苔根腻，脉弦细。服甘草泻心汤原方：炙甘草10克，半夏15克，黄连6克，黄芩6克，党参6克，干姜10克，大枣10枚。三剂后诸症明显改善，苔黄已去，大便调畅，原方又服三剂而安。

44.旋覆代赭汤证

呃逆案

黄某，女，12岁。曾患脑膜炎，经治疗后已愈，遗有呃逆一证，伴不欲饮食。前医以为温病伤阴，用五汁饮及叶氏益胃汤等，反添胃中发凉之症。舌苔白略腻，脉弦无力。此胃脘阳虚，津聚为饮，内挟肝气上逆所致。

旋覆花9克 代赭石6克 生姜15克 党参6克 半夏9克 大枣7枚 炙甘草6克

服药三剂后，呃逆止，胃冷除而饮食增。方中又加茯苓 15克，陈皮9克调治，四剂而安。

【解说】

温热病后期，虽然以伤阴为多见，但也不乏胃气受损者。呃逆而不欲饮食，反映了胃气虚弱而上逆，仲景之法，用糜粥调养，日久之后中气渐复而病能自愈。他医用五汁饮、益胃汤等甘寒之品，反伤中气，所以增添胃中发凉。旋覆代赭汤能调和脾胃，降逆平冲，消散痰饮，治法与病机相应，所以效如桴鼓。

旋覆代赭汤的组方以旋覆花为主，花者质轻在上，有上行的特点，而旋覆花味咸又有下降的作用，能升能降，所以既能疏肝利肺，又能消散凝结之气。代赭石为矿物药，入肝经而有镇肝降逆的作用，使肝气条达下行为顺，所以用量宜小而不宜大，以免其质重直走下焦，影响疗效的发挥。从临床上看，旋覆代赭汤特别适用于妇女因情绪波动而引起的肝胃失和病变。

45.黄连汤证

(1) 久利案

李某，男。患大便下痢挟有红白黏液，每日三四次，且里急后重已一年多，伴恶心呕吐，腹痛，各处就医无效。舌质红而苔白，脉弦滑按之无力。此乃寒热错杂之邪，分据脾胃上下，若纯用寒药治热，或纯用热药治寒，皆不能奏效，必须寒热并治。

黄连9克 干姜9克 桂枝9克 半夏9克 党参6克 大枣7枚 炙甘草6克

前后共服六剂，一年之病从此而愈。

(2) 上热下寒案

侯某，女，55岁。患上热下寒证，每于进食后约一小时，胃气上逆而泛恶吐酸，胸中憋闷疼痛；同时伴见腹痛肠鸣，大便溏稀。舌淡苔白，脉弦。黄连汤主之。

黄连10克 干姜7克 桂枝9克 炙甘草10克 党参10克 半夏10克 大枣5枚

服药五剂，寒热之证尽愈。

【解说】

黄连汤由半夏泻心汤减黄芩加桂枝而成。虽然取意于泻心汤，但立法则与之有别，黄连清胸中之上热，干姜温脾胃之下寒，妙在加桂枝下气降冲，宣通上下，而使气机调顺。

又附：肠痈案

吴某，女，30岁。患右侧少腹疼痛已4天，喜温喜按，大便稀溏，每日二三次，时时欲呕。脉弦，舌质淡而苔黄。西医诊断为：慢性阑尾炎急性发作，血象：白细胞 $12 \times 10^9/L$ 。从其舌脉证来看，既非单纯热凝，亦非单纯寒结，初用连理汤虽然有效但不明显，后用黄连汤治疗：黄连9克，干姜6克，桂枝6克，党参9克，半夏9克，大枣7枚，炙甘草6克，黄芩6克。服药三剂后，诸证皆退。

46.黄芩汤证

热利案

王某，男，28岁。初夏迎风取爽受凉后，病头痛而身热，经治表证已解，但出现大便下痢，肛门灼热，每日四五次，伴腹中疼痛，里急后重及口苦、恶心等证。脉弦数而滑，舌苔黄白相杂。此属少阳经热内注于胃肠，以致腑气不和。

黄芩10克 白芍10克 大枣7枚 炙甘草6克 半夏10克 生姜10克

服药三剂而愈。

【解说】

黄芩汤证，《伤寒论》虽然说是属于“太阳与少阳合病”，但仍然以邪热郁于少阳为主。少阳有邪，则胆气郁而不疏，最易横犯胃肠，上逆于胃则呕吐，下迫于肠则下利。又因为少阳疏泄不利，气机不畅，所以下利往往兼有大便不爽，下重难通，肛门灼热等证。黄芩苦寒，善清少阳郁热，芍药苦酸，能益阴柔肝，以制少阳木气之横逆。二药相合，是治疗热性下利的主药。现代临床上多用黄芩汤来治疗热利，后世治疗痢疾的著名方剂“芍药汤”即从黄芩汤演化而来，所以，汪昂的《医方集解》称黄芩汤为“万世治利之祖方”。

47.白虎汤证

(1) 高热案

孙某，女，3岁。患女出麻疹后，高热不退，伴见汗出，一身未了又出一身，汗虽多而热不消，口干舌燥唇焦，频频饮水不止。舌苔薄黄，脉滑数。此属阳明气分大热，迫津外渗，若不急治，恐有津亡痉厥之变。

生石膏30克 知母6克 炙甘草6克 粳米一大撮

服药一剂，即热退身凉，汗止脉和而安。

(2) 热厥案

郑某，男，22岁。外感时令邪气，高热，口燥渴，神志昏糊，睡时呓语频作，手足厥冷，小便色黄，大便尚能通畅，脉洪大有力，舌质绛红苔黄。此属“热厥”，而有内闭心包之势，治当辛寒重剂，急清邪热；少佐芳香开窍，以杜邪气逆传心包。

生石膏30克 知母9克 炙甘草6克 粳米一大撮 广角3克 连翘心3克 菖蒲3克 郁金3克

服药仅二剂，热消厥退，神志清醒。

(3) 汗多案

刘某，女，5岁。出麻疹后，发热不退，周身大汗淋漓，口舌干燥，渴喜冷饮，舌质红，苔薄黄而干，脉滑大。阳明热邪弥漫内外，尚未敛结成实。但汗出多必然伤津，舌红而干，已知邪热有深入营分之势，治疗宜清气分热邪为主，兼顾营分阴液。

生石膏34克 知母6克 炙甘草6克 粳米一撮 生地6克 丹皮6克 二剂。

服药后，汗止热退而愈。

【解说】

白虎汤是治疗阳明气分热邪内盛，弥漫全身，充斥内外而设，仲景称为“热结在里，表里俱热”。在临床上以大热，大汗，大渴，脉来洪大等作为其辨证要点。因为热邪炽盛于气分，蒸腾内外，所以发热程度比较严重，而且是“不恶寒，反恶热”，这是阳明发热与太阳发热的主要鉴别。在发热的同时，往往伴随着汗出，由于这种汗出是里热蒸腾逼迫津液外渗所引起，所以往往汗出不断，这在《伤寒论》中被称为“濇然汗

出”，即汗出擦干未几又出一身，随擦随出。

麻疹出后，犹高热不退，汗出而渴，脉洪大或滑数者，反映了邪未解，气分之证已明，再用宣透之法无济于事，所以用白虎汤清泄气分邪热则愈。如果疹出不透，内陷于肺而引起高热，喘咳，肩耸鼻煽，这是气分之热在肺而不在胃，所以不用白虎汤清胃而用麻杏甘膏汤清肺透热。古人用麻黄不分寒热，而重在配伍：小青龙汤麻黄配干姜则治寒喘；麻杏甘膏汤麻黄配石膏则治热喘。寒热不同而用麻黄则一，突出了麻黄治喘的特效。

（4）误用石膏救逆案

曾治一外感患者，发热一直不退，认为是卫分温邪所致，投银翘散辛凉解表无效，又在银翘散中加入生石膏，患者服药后不但发热未退，反而又出现神昏谵语等险象。经人介绍，请来某老医生会诊。老医生视方叹曰：风寒束表反用辛凉重剂，冰遏阳气，迫使表邪内犯，非刘君一人医门，比比皆是也。老医生乃用雄鸡冠血数滴溶合黄酒、蜂蜜少许，加温服下。覆被取汗后，前胸后背发出一层白色疹子，热退神安而愈。

【解说】

白虎汤具有很强的清热作用，这种作用主要归功于石膏。石膏的清热作用主要适用于阳明气分热邪，所以，必须是热邪已经入里，方可放胆使用。如果“发热无汗，其表不解”，必须禁用。误用就会导致冰伏邪气，引盗入室的危险。吴鞠通《温病条辨》把白虎汤当作辛凉重剂，认为用之不当，祸不旋踵。他说：“白虎本为达热出表，若其人脉浮弦而细者，不可与也；脉沉者，不可与也；不渴者，不可与也；汗不出者，不可与也”。说明凡邪热不盛之脉证，都不能操之过急，诚恐无热用清反有倒戈之变。另外，邪热既已入里，用白虎汤清热，犹应观其脉证加减化裁，则可一举而收功，不然，顾前不能瞻后，必然失于主动。如郑案神糊呓语，不必待其神昏谵语则佐以广角、菖蒲、郁金、连翘心等以开心窍；刘案舌红而干，不必待其舌绛发斑则佐以生地、丹皮以救营阴，都是因为能见微知著，当机立断，所以能防变于治疗之先。

48.白虎加人参汤证

消渴案

李某，男，52岁。患者有糖尿病史。口燥渴多饮，饮水后复渴，有饮水不能解渴之势。虽多饮但小便却黄，纳食减少，神疲体乏，大便正常。脉大而软，舌质红无苔。证属肺胃热盛，气阴两伤所致，治疗当以清上、中之热而益气阴之虚为宜。

生石膏40克 知母10克 炙甘草6克 粳米一大撮 人参 10克 花粉10克

上方服五剂后，口渴大减，体力与精神均有好转。转用益胃阴法：沙参12克，玉竹12克，麦冬30克，天花粉10克，知母6克，太子参15克，甘草6克等，连用十余剂，证情逐渐稳定，遂改用丸药巩固疗效。

【解说】

白虎加人参汤，清热之中兼能益气养阴，功用全在人参一物，能大补元气而生津止渴。本方与白虎汤的主要区别在于津液匮乏，而又元气大伤，口中燥渴程度特别严重，《伤寒论》描述为：“大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者”。若只用白虎汤清热止渴不足以治其本，还必须加用人参益气生津方能达到治疗目的。

49.白虎加桂枝汤证

（1）温疟案

张某，女，32岁。新产后才九日，即外出产房，因而感受风寒，起病突然，寒战振栗，继而身半以上汗出，烦热难忍，身半以下无汗，反觉寒冷彻骨。口干渴能饮，其人面色红赤，左额头疼痛，但项背恶风。脉浮大，舌质红绛，苔薄白。合而观之，知其人素体阳热内盛，值新产之后，血气虚弱，风邪乘虚而入。阳热内盛，因风邪诱发而壅聚于上，气不能下达，所以出现上热下寒，内热外寒的情况。治疗必须内清其热，外解其风。

生石膏30克 知母10克 炙甘草6克 粳米一大撮 桂枝6克 白薇10克 玉竹10克

服药仅一剂，诸症霍然而愈。

【解说】

《金匮要略·疟病篇》说：“温疟者，其脉如平，身但寒无热，骨节疼痛，时呕，白虎加桂枝汤主之”。温疟证的产生机理是本有伏热在内，因感受时邪引发外出，尤在泾认为是“邪气内藏肾中，至春夏而始发，为伏气外出之证”。药证与病机相合，所以一剂而愈。

（2）更年期综合征案

赵某，女，50岁。月经周期紊乱，近半个月来经量或多或少，近日又出现阵发性的肢体颤抖，周身疼痛不适，伴见面色潮红，烘热汗出，失眠，口苦，渴喜凉饮。舌质红，苔薄黄，脉弦略数。西医诊断为更年期综合征。中医辨证属于阴分不足，内热蕴于阳明而外盛肌表，治用白虎加桂枝汤清热滋阴，解肌以和营卫。

生石膏30克 知母10克 桂枝10克 粳米10克 炙甘草10克 三剂。

服药后显效，身已不抖不痛，夜寐转佳，但仍喜凉饮，上方去桂枝，加生地、玄参、龙骨、牡蛎，再进六剂后，诸症悉平。

【解说】

白虎汤原可清阳明气分之热，加桂枝透邪外出，使其溃不成军，邪热势孤则愈。本方之妙，在于石膏与桂枝相配。综观《伤寒杂病论》，仲景将石膏配桂枝主要用于两大方面：其一，内有水饮邪气，日久郁而化热，形成饮中挟热之势，用桂枝通阳化饮，配石膏以清饮中之郁热，

如小青龙加石膏汤证，木防己汤证等；其二，寒邪外束，内有伏热，形成“寒包火”之势。“寒包火”，一是先感于寒，寒邪闭遏使阳气不宣，以致郁而化火；二是先有伏热在内，复又外感寒邪，以致伏热不得外达。前者如大青龙汤证，后者如白虎加桂枝汤证，只要具有“寒包火”之证机，就必须用石膏清其内热，桂枝引其邪热而外出。

50.白虎加苍术汤证

湿温高热案

周某，男，24岁。病高热，头痛身疼，胸中满闷，恶心不欲饮食。曾注射“安乃静”二支，汗出较多但发热却不退，体温持续在39.6℃上下，有时呕吐，夜寐则呓语。脉浮数，舌苔白腻。初用三仁汤以清利湿热，服药后发热未消，而体痛不可耐，患者家人催促再诊。脉转濡数，舌质红，苔黄白杂腻，面色红赤，口渴思饮，足胫反冷，小便黄赤，大便不燥。细审此病，曾经发汗，津液受损可知，口渴喜饮，睡则呓语，热在阳明无疑；然而发热虽甚但身反无汗，而且身痛沉重，胸满作呕，足冷尿黄，舌苔又腻，则热中挟湿之情昭然若揭。此证非白虎汤不足以清其热，非苍术不足以化其湿浊。

生石膏30克 知母10克 苍术10克 粳米一大撮 炙甘草6克

服药仅一剂，则热退痛止，诸症迎刃而解。

【解说】

白虎加苍术汤出自《伤寒类证活人书》，治疗湿温病症见身重，胸满，头疼，妄言，多汗，两胫逆冷等。用白虎汤清气分热邪，加苍术燥热中之湿，临床用本方治疗湿温气分高热甚有疗效。

又附：湿温高热案

曾治一患者，高热不退，午后为甚，住院治疗已一周多，曾服用三仁汤、银翘散等方药，并注射各种抗生素皆无效。症见汗出多，但热不能随汗出而外越，扪其额头，其热不扬，伴见渴欲饮水，头痛且重，小便黄短，舌质红苔黄腻，脉滑数。从辨证角度分析：高热，汗出，口渴，脉滑数，白虎汤证俱；但发热以午后为甚，其热不扬，且头重痛，小便黄短，舌苔腻，内有湿邪相挟为患。用白虎加苍术汤原方，服药二剂后，热退身凉而安。

51.调胃承气汤证

久利案

安某，男，38岁。患慢性痢疾一年多，大便每日三四次，兼挟黏液，有下坠感，伴腹胀肠鸣。舌质红苔黄，脉弦。先按厥阴下利治疗，用白头翁汤加白芍、麦冬，二剂后大便黏液明显减少，但仍腹胀肠鸣而下坠，此属热结阳明胃肠，气机不利，通因通用，宜从调胃承气汤法。

大黄9克 风化硝9克 炙甘草9克 白芍15克 川楝9克 青皮9克

服药一剂后，大便泻出黄黑色粪垢甚多，顿觉腹中宽适。宗前法用调胃承气汤原方又一剂，诸症皆消。

【解说】

承气者，用以承顺胃肠六腑之气机。胃肠六腑之气不顺，责在内有邪气凝滞。大、小、调胃三承气汤都能攻逐胃肠六腑凝滞之邪，所以皆能承顺气机下行。病有大便硬结，腹满腹痛者，是由于腑气不利；有大便下利，腹满腹痛者，亦由于腑气不利。所以三承气汤，不但能治大便硬结，又都能治疗大便下利。用三承气汤治疗胃肠实热内结的大便硬结易明，但用此三方治疗大便下利却不易明。大、小、调胃三承气汤，药味各异，剂量不同，煎服方法亦各有特点，所以治疗有大小轻重缓急之分。如下利后重，腹胀疼痛俱盛者，证情急迫较重，用大承气汤；下利后重，以腹胀为主者，用小承气汤；下利后重，虽有腹胀而证情轻缓者，用调胃承气汤。由此可见，承气汤的主要作用在于逐邪通腑，凡下利后重，以腑气不利为主，有明显腹部胀满表现者，切其脉沉滑有力、舌苔黄厚不退都可以用承气汤一下治之。

52.小承气汤证

（1）腑实腹痛案

陈某，男，12岁。过端午节时多吃了几个粽子，第二天胃痛腹胀，啼哭不止。其父前往药铺购买“一粒丹”与服之，不但无效，腹痛反而加剧。询知大便已3日未解，解衣观腹，腹胀如合瓦，以手按其腹则叫哭不已。脉沉滑有力，舌苔黄白杂腻。此因过饱伤中，食填太仓，胃肠阻滞，气机不利所致。

大黄9克 枳实9克 厚朴9克 藿香梗6克 生姜6克 一剂。

服药后约一个时辰，腹中气动有声，旋即大便作泄，泻下酸臭物甚多，连下两次，腹痛止而思睡。转用保和丸加减善后。

（2）大实类虚案

张某，男，21岁。患者头晕体疲，不欲饮食，勉强进食则腹中胀痛不已。自以为体虚而前来求开补药方。询问先前所服药物，皆人参健脾、十全大补等丸药，不但不见疗效，而反更显体弱无力。视其舌苔黄腻，切其脉滑而有力，不属虚证，因而再问其二便情况，果然大便干硬而小便黄赤。此乃大实而有虚候，胃肠内有结滞，胃气不降，燥热上熏，干扰清阳则头晕；腑气壅滞不通故腹胀疼痛；气蕴于里而不达于外则体疲乏力。土气太过，则成敦阜，必以泻药平之。

大黄9克 枳实9克 厚朴9克

服药一剂后，大便泻下3次，头晕顿时减轻，周身轻爽如释重负，腹胀愈其七八。后用平胃散调和胃气而愈。

【解说】

小承气汤是为治疗大便已经成硬，但尚未至燥屎的程度。所谓大便已经成硬，指的是大便干硬，但犹能形成条状。临床所见，腹部胀满，大便干硬，辨为小承气汤证比较容易。但腑气不通，邪实于内，反见虚羸之象者，却不容易辨认。曹颖甫用大承气汤治头痛，认为是“阳明燥气上冲及脑”；本案用小承气汤治头晕，辨为“燥热上熏，干扰清阳之位”。二者方证虽然不同，但其辨证思路及治法的选择则基本一致。这类情况临床不属少见，应该引起注意。

此外，凡服承气类方剂，临床要注意两个问题：一是辨证明确时，当下则下，若明知腑实当下，而又恐攻下伤正，则延误病情；二是服药

后，得大便利则止后服，不可过服求快反而伤正。

53.大承气汤证

热利案

李某，男，35岁。病下利腹痛，肛门灼热如火烙，大便后重难通。曾自服“十滴水”，腹痛当时得以减缓，下利3日未作。至第四天，腹痛又发，较前更严重，里急后重，下利皆为红白黏液，有排泻不尽之感。以手按其腹，疼痛叫绝。脉沉有力，舌苔黄厚。其证始于胃肠积热，乃葛根芩连汤证，反服“十滴水”热性之品，使邪热凝结不开，以致气血腐化为红白之利。治当通因通用，荡涤胃肠积滞以推陈致新。

大黄10克 元明粉10克 枳实10克 厚朴10克 滑石10克 青黛3克 甘草3克

服药一剂后，大便泻下黏秽数次，诸症随即而愈。

【解说】

仲景立大承气汤是为治疗阳明病腑气不通，燥屎内结而设。所谓“燥屎”指的是大便干燥，坚硬成球如羊屎，这反映了燥热邪气伤津，糟粕凝结，嵌顿于肠内而不得排出体外。所以，一般来说，必须具备腹部痞满疼痛，大便燥坚与潮热的证候特点。大承气汤具有泄热软坚，荡涤胃肠，攻逐六腑的作用，其力甚大，不但燥屎内结必用之，凡秽浊邪气凝结不开，腑气不利时也可用之，如本案治疗热利，抓住“以手按其腹，疼痛叫绝”这一特点，参合舌脉，非荡涤胃肠积滞不能取功，故用大承气汤一剂而效。前人吴又可对此独具见识，他说：“承气本为逐邪而设，非专为结粪而设也。必俟其粪结，血液为热所搏，变证迭起，是犹养虎遗患，医之咎也。况多有溏粪失下，但蒸作极臭，如败酱，或如藕泥，临死不结者。但得秽恶一去，邪毒从此而消，脉证从此而退，岂徒孜孜粪结而后行哉？”

54.麻子仁丸证

脾约证案

刘某，男，28岁。患大便燥结，五六日排解一次，每次大便时，往往因努责用力而汗出湿衣，但腹中无所苦。口唇发干，用舌津舐之则起厚皮如痂，撕之则唇破血出。脉沉滑，舌苔黄。此是胃强脾弱的脾约证。

疏以麻子仁丸一料，服尽而愈。

【解说】

麻子仁丸由小承气汤加麻仁、杏仁、芍药，和蜜为丸而成，治疗“脾约证”。脾约有两个含义：一，约者，穷乏也。津液素亏，脾无津液输布而穷约。二，约者，约束也。脾之弱阴被胃之强阳所约束，津液不能还于胃中。为什么会形成脾约？在正常情况下，阳明与太阴相表里，脏腑之气相通，脾能为胃行其津液而使燥湿相济，以维持脏腑间的阴阳平衡。如果阳明胃气过强而太阴脾阴太弱，则胃之强阳反凌脾之弱阴，使脾阴受约而不能为胃行其津液；津液不能还于胃中，胃肠失于濡润而干燥，大便因此而难下。所以，脾约证仍属阳明腑实证之一，但是这种大便难有以下特点：经常性和习惯性的大便秘结，其粪块异常干硬，虽然数日不大便，但无腹满腹痛，潮热，谵语等证，所以不属于承气汤的治疗范围，而应该用麻子仁丸润下通便。

55.厚朴七物汤证

挟滞伤寒案

某男孩，8岁。外感风寒，发热头痛，无汗，又内挟食滞，腹中胀痛，大便不通。脉浮紧，舌苔黄白杂腻。

大黄6克 厚朴9克 枳实6克 桂枝3克 麻黄3克 杏仁3克 甘草3克

服药一剂，大便通达，汗出热退而解。

【解说】

厚朴七物汤见于《金匱要略·腹满寒疝宿食病篇》，治疗腹满便秘而又有发热脉浮等证。本方由厚朴三物汤合桂枝去芍药汤而成，具有表里双解的作用，但此方重用厚朴，轻用桂枝，所以治疗偏重于里，为七里三表之法。

本案由于发热无汗证属表实，所以取厚朴七物汤之法而易姜、枣为麻黄、杏仁，加强了达表散寒的作用，治疗表里各半之证，所以一剂药后则使表里气机畅达，汗出便通而安。亦可谓师古而不拘泥于古。

56.茵陈蒿汤证

（1）黄疸案一

刘某，男，14岁。春节期间，因食荤腥肥甘太过，又感受时邪，因而发病。开始时发热恶寒，不欲饮食，心中懊^懔，不时泛恶欲吐，小便黄赤。继而全身面目黄染，体疲乏力，大便尚可。经某医院确诊为“急性黄疸性肝炎”。脉弦而滑数，舌苔黄腻。此为外感时邪与内湿相合，蕴郁肝胆疏泄不利所致。

茵陈30克 大黄9克 栀子9克 土茯苓12克 草河车9克 凤尾草9克

上方服三剂后，证情减半。去土茯苓、草河车、凤尾草，加柴胡12克，黄芩、半夏、生姜各9克，大黄减至6克。又服三剂，黄疸已退，诸证皆平，改用茵陈五苓散善后。

（2）黄疸案二

张某，男，38岁。患急性黄疸性肝炎，发热38.8℃，右胁疼痛，口苦，恶心，厌食油腻之物，一身面目尽黄，大便不爽，小便短黄。舌苔黄腻，脉弦滑数。

茵陈30克 大黄9克 栀子9克 柴胡12克 黄芩9克 半夏9克 生姜9克

三剂后，大便畅泻，小便通利，黄毒从二便而去，诸症悉退。三日后，黄疸又作，此乃余邪未净，仍服上方而退。

【解说】

茵陈蒿汤是《伤寒论》中治疗湿热发黄的一首名方，临床上用本方治疗各种黄疸，特别是治疗肝胆疾患所引起的黄疸，无论急、慢性，多能取效，这一点已被大家所公认。在此只需要补充二点：一、常用加味法：若兼胁肋胀满或疼痛者，加柴胡、黄芩；恶心呕吐者，加半夏、生姜；湿毒盛而证形剧者，加土茯苓、草河车、凤尾草；两足发热者，加知母、黄柏。二、经验证明，凡治湿热黄疸，其病多缠绵难愈，这与湿邪黏腻难去有关，所以不可操之过急，治疗时务必使湿热邪气尽去方能罢手，否则病情反复，将更加难于治疗。如小便黄赤者，服药后必须以尿色变清为准；大便灰白者，服药后必须使大便转为黄色为准，否则，停药过早，容易复发。另外，有的患者病后周身乏力，疲惫不堪，切勿错认为虚证而妄投补益之品，仍需用清热利湿之法，使湿热尽去，体力即能逐渐恢复。

57.麻黄连翘赤小豆汤证

(1) 湿疹案

李某，男，35岁。患湿疹，头身泛起瘡蕾，红如花瓣，苦搔痒不得释手，皮破水渍，抓痕累累，伴低热恶寒。舌苔白略腻，脉浮。证属风寒客于营卫之间，郁而蕴湿，外发为瘡。治当发汗祛风，兼以渗湿。

麻黄9克 连翘9克 杏仁9克 桑白皮9克 苦参9克 赤小豆30克 木通9克 大枣7枚 炙甘草3克 二剂。

药后温覆，汗出较多，头身瘡疹随之而消。

(2) 湿毒外发案

王某，女，8岁。有慢性肾炎病史，现症：颜面浮肿，色黄不泽，周身皮肤刺痒颇剧，搔之则泛起小疙瘩。曾经中西医多方治疗无效。舌质红苔白滑，右脉滑，左脉略浮。此证因于小便不利，湿邪内蓄，水毒不化而渗透于肌肤，郁遏阳气不得宣泄而致。

麻黄3克 连翘6克 赤小豆15克 杏仁6克 桑白皮6克 桔梗3克 苦参6克 生姜12克 大枣5枚 炙甘草3克

服药一剂，汗出而痒除。

【解说】

麻黄连翘赤小豆汤，在《伤寒论》中用来治疗“伤寒瘀热在里，身必发黄”。本方有麻黄、杏仁、连翘、生姜以宣散在表之邪，赤小豆、梓白皮（现多改用桑白皮）以清在里之湿毒。外能解表散热，内能利湿化毒，此乃开鬼门，洁净府两法兼备。临床用于急性黄疸初起，荨麻疹或其他皮肤瘙痒，脉浮表不解的，效果较好。此方又治慢性肾炎小便不利，对续发的皮肤瘙痒有特效。

58. 梔子柏皮汤证

久黄案

唐某，男，17岁。患亚急性肝坏死，住某传染病院治疗已三个多月，周身发黄如烟熏，两足发热，夜寐时必须将两足伸出被外，脘腹微胀，小便黄赤。舌质红绛，脉弦。此为湿热久蕴，伏于阴分，正气受损。

梔子9克 黄柏9克 炙甘草6克

服药六剂后，病情好转，但又显现阴液不足之象，至夜间口干咽燥，津液不滋，上方合大甘露饮法：

梔子 黄柏 黄芩 茵陈各3克 枳壳 枇杷叶 丹皮 石斛 麦冬 赤芍各9克

上方连服十二剂后，黄疸基本消退，因而改用和胃健脾、化湿解毒等法，调治达半年之久而愈。

【解说】

梔子柏皮汤的组方妙在用炙甘草和中健脾，益气补虚，并可监制梔子、黄柏苦寒伤胃之弊。但临床上如何使用本方，却难为医家所掌握。一般来说，凡湿热黄疸不是表里之证，或用茵陈蒿汤等清热利湿之后，黄疸未尽，而人体正气已损，阴分尚有伏热，如见五心烦热等证，用本方效果较好。

59.小柴胡汤证

(1) 低热案

张某，男，36岁。患低热（37.5℃左右）多年不愈，伴见盗汗，心烦等证，西医怀疑为肺结核，但经检查后没有发现结核病灶，转请中医治疗。胁脘痞满不舒，纳少而口苦，舌质红、苔白润，脉弦细。

柴胡12克 黄芩6克 生姜10克 半夏10克 党参6克 大枣7枚 炙甘草6克

连服五剂后，胁脘痞满渐消，口不苦，饮食增进，体温降至37.2℃。转服丹栀逍遥散五剂而愈。

【解说】

大凡肝胆气郁日久不解者，多能化火伤阴，所以古人说：“气有余便是火”。气郁之初每见胸胁苦满，脘腹不舒，时时太息为快；化火伤阴则可出现盗汗，心烦少寐，以至于低热缠绵不退。治疗时应宗“火郁发之”、“木郁达之”的原则，采用开郁疏肝的方法。如果按壮水之主以制阳光论治，妄投滋水补阴之品，反使气机受阻，郁结不开，必然徒劳而无功。

(2) 往来寒热案

沈某，女，42岁。始因恚怒伤肝而心胸发满，不欲饮食。继而又外感风寒邪气，往来寒热，休作有时，伴胸胁苦满，头痛身疼。脉弦，舌苔白滑。此少阳受邪，气郁不舒，枢机不利之证。

柴胡12克 黄芩9克 半夏9克 生姜9克 党参6克 大枣7枚 炙甘草6克

服药一剂，则寒热俱减，又服一剂后诸证皆消。

【解说】

寒热往来是小柴胡汤的主证之一，也是少阳病枢机不利，正邪交争的典型临床表现。先有恶寒，后见发热，恶寒时不发热，发热时不恶寒，二者交替发作，所以称之为“休作有时”。临床凡见到往来寒热，就应该首先考虑用小柴胡汤治疗。

(3) 头痛案

李某，女，34岁。患血管神经性头痛，经多方求治，疗效甚微。头痛每星期发作3次，剧烈难忍，欲以头冲撞墙壁，每次发作时多伴喷射性呕吐，周身燥热，时有胁下作痛，素常月经量少。脉沉，舌苔腻。证

属肝胆郁热上扰头位，治用小柴胡汤法。

柴胡12克 黄芩10克 半夏12克 党参6克 生姜12克 大枣3枚 炙甘草6克 白芍30克 丹皮12克 夏枯草10克 龙胆草9克

一个月后复诊，告知上方服用十二剂，效果明显，头痛由每周发作三次降至一月内仅发作一次，痛势明显减轻。效不更方，又继续服上方近十五剂，头痛得以控制。

【解说】

小柴胡汤治疗头痛一般不为临床医家所重视，但《伤寒论》中曾指出：“伤寒，脉弦细，头痛发热者，属少阳也”。说明了头痛也是少阳病的常见症状之一，所以，从辨证角度看，头痛而兼有其他少阳证者，即可以用小柴胡汤加减进行治疗。

（4）胁背胀痛案

姜某，女，40岁。其人喜怒无常而善郁，近日胸胁及背部胀满疼痛，口中干苦，脉沉弦有力，舌质红苔白腻。此气郁不疏，少阳经气不和之变。

柴胡12克 黄芩10克 半夏9克 生姜9克 党参6克 大枣5枚 炙甘草6克

服药三剂后，口苦除，胁背疼痛消，但胸胁偶觉发胀。改服四逆散加黄芩、当归，三剂而安。

（5）腰痛案

张某，男，33岁。患单纯性腰痛近三年，口干渴欲饮，无头晕耳鸣等。舌质红绛，脉浮弦有力。辨为少阳气郁，木邪反侮其母，肾水被木火所伤。

柴胡12克 黄芩10克 半夏10克 生姜10克 党参6克 炙甘草6克 桑寄生30克 丹皮10克 白芍10克

服药六剂后，腰痛减半，照方又服三剂而愈。

【解说】

腰为肾之外府，所以腰痛多从肾论治。本案不从肾治，而从少阳论治者，是因为考虑到病程已久，而无明显虚实之象，则病本不在肾。

《灵枢·本输》指出：“少阳属肾，肾上连肺，故将两脏”。说明了少阳与肾经脉相通，少阳相火为病也可下伤肾阴。所以，本案用小柴胡汤而治少阳取得了人意料的疗效，可见少阳相火所致之低烧、盗汗、腰痛，只能疏达而不能滋补。

（6）二阳并病案

鲁某，男，46岁。外感风寒已六七日，仍恶寒、头痛不解；又出现胁下胀满，恶心欲吐，脉浮弦，舌苔白滑。此太阳邪气并入少阳，以致少阳气郁不疏。

柴胡15克 黄芩12克 半夏15克 生姜15克 党参10克 大枣12枚 炙甘草6克

服药一剂后，病人突然寒栗而振，肢体抖动不止，其脉沉伏不起。此是邪气由少阳枢机运转而外出太阳，正邪交争，将有战汗之机。急令饮热水一大杯，少顷果然由寒变热，继而通身大汗如洗而病愈。

（7）便秘案

韩某，女，52岁。患大便秘结已一年多，每隔三四天一次，每次登厕必努责用力，以致衣里汗湿，大便虽下，而其人已疲惫不支。伴见胸胁苦满，口苦，心烦等证。脉弦，苔白滑。

柴胡12克 黄芩10克 半夏10克 生姜6克 党参6克 大枣7枚 炙甘草6克

服药三剂后，大便畅然而通，胸胁满亦除。

（8）浮肿案

某村妇与其姑相口角，忿怒之余，口咽发燥，乃暴饮凉水。次日胸胁发满，小便不利，下肢浮肿。脉沉弦，苔白滑。

柴胡12克 黄芩6克 半夏10克 生姜10克 党参6克 大枣6枚 炙甘草6克 桔梗6克 枳壳6克

服药二剂后，胸胁满消。上方加茯苓10克，又进二剂，小便自利而下肢肿消。

【解说】

上列鲁案、韩案及村妇案，尽管其主病各不相同，但其病证皆有胸胁苦满，其病机皆与少阳气郁不疏，枢机不利，三焦不通有关，所以遵循“有柴胡证，但见一证便是”的原则，以小柴胡汤解郁利枢为主，使其上焦得通，津液得下，胃气因和，表里上下之气得达，则汗出而表证解，二便通而里证除。

（9）呕吐案

徐某，女，29岁。患顽固性呕吐已三年多，往往在进食后1~2小时即呕吐酸苦而多涎，右胁发胀，连及胃脘疼痛。脉沉弦而滑，舌苔白滑。

柴胡12克 黄芩9克 半夏14克 生姜14克 党参6克 炙甘草6克 竹茹12克 陈皮12克 郁金9克 香附9克 牡蛎12克

上方共服六剂，呕吐再未发作。

【解说】

《素问·逆调论》说：“邪在胆，逆在胃”，指出了肝胆与脾胃之间的密切关系。肝胆之气的疏泄直接有利于脾胃气机的上下升降及其受纳运化水谷的功能。如果肝胆气郁不疏，则脾胃功能必然因之而失调。所以在少阳病中多见胃气上逆而致的呕吐，如《伤寒论》说：“呕而发热者，小柴胡汤主之”。又说：“脏腑相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之”。由此观之，小柴胡汤确实是治疗气郁呕吐的良方。

（10）盗汗案

袁某，男，64岁。外感时邪，乍寒乍热，两胁苦满，伴咳嗽有痰，口苦，心烦，至夜间合目则盗汗出，湿透衣被，甚以为苦。脉弦有力，舌苔白滑。此冬令时邪，先犯肺卫，治不如法，乃传少阳。少阳气郁不疏，相火内蕴，逼迫津液外出，故见盗汗。

柴胡12克 黄芩10克 半夏10克 生姜6克 党参9克 生石膏15克 炙甘草9克 鱼腥草10克 桔梗6克

服药三剂，盗汗止而诸证愈。

【解说】

《伤寒论》说：“三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗。”今人治盗汗，多从阴虚论治，一般不从阳邪考虑。殊不知少阳本寓相火，邪入少阳，则气郁火蕴；至夜间目合之时，阳入于阴，阳热内迫，则里热更甚，里热甚则逼津外出，亦往往导致盗汗。此亦属于少阳枢机不能主阴阳表里气机出入之变，所以用小柴胡汤解郁利枢而能止其盗汗。

又：小柴胡汤，仲景原本是为治疗少阳病而立，凡邪气侵犯少阳，气机郁勃不疏，肝胆疏泄不利，少阳经腑功能失常，则为少阳病。

少阳包括足少阳胆与手少阳三焦，应时在春，五行属木，禀条达疏泄之性，具启陈致新之能，所以少阳之气喜条达而恶抑郁，喜疏泄而恶凝滞，有如春气之升发而万物生，则少阳之气对于人体周身气机的运动有促进并调节的作用。所以少阳为枢，能为人体表里阴阳、内外上下、气血津液、脾胃三焦之枢，能枢转周身气机的升降出入运动，促进气血津液的运行。如果少阳受邪，不但使少阳经腑功能失常而为病，而且每因少阳气郁不疏，枢转无力，使得周身气机运动亦因之而郁，内外上下之气不通，气血津液不行，则诸病生焉。小柴胡汤具解郁利枢之能，有推陈致新之功，善开少阳气郁以利枢机之用，所以，小柴胡汤为少阳枢

机之剂，实乃仲景开郁利气之首方。

凡病及少阳，与少阳气郁，枢机不利有关，见有往来寒热，胸胁苦满等证，皆能用小柴胡汤治疗。所以仲景指出：“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具”。学者不可以此而非小柴胡汤为治疗少阳病的主方，亦不可以彼而非小柴胡汤解郁利枢的作用。一般总把小柴胡汤的治疗作用说成是和解少阳，但“和解少阳”四个字决不能概括小柴胡汤治疗作用的方方面面。从小柴胡汤的组方来看，其中的药物可以分为三组：一是柴胡配黄芩。柴胡微苦寒，感一阳春升之气而生，能直入少阳，升足少阳之清气，既解少阳经中之邪，又能疏利肝胆气机而推动六腑之气，具有推陈致新的作用，黄芩苦寒，善于清泄少阳胆腑火热。柴芩相配，一升一降，经腑同治，能使少阳气郁得达，火郁得发，郁开气活，则枢机自利。二是生姜配半夏，既能和胃止呕，又因为姜、夏味辛能散，有助于柴胡疏解少阳之郁滞。三是人参、大枣与甘草相配，味甘补中，一方面能鼓舞胃气以助少阳枢转之力，另一方面还能预补脾胃之气，以杜绝少阳邪气内传之路。全方既有祛邪之品，又有扶正之药，集寒热补泻于一体之中，具有升达少阳生气，疏解肝胆气郁的作用，能开郁调气而利升降出入之枢。枢转气活，则内外上下、表里阴阳之气得以通达和利，气血津液随之周流而布达于身形各部，从而气机调畅，脏腑安和。

综观《伤寒论》与《金匱要略》二书，凡用小柴胡汤治疗者共二十条，归纳起来，其治疗范围包括以下几个方面：①少阳病，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕及口苦，咽干，目眩等；②少阳病兼太阳表证；③少阳病兼阳明里证；④少阳病兼脾家气血不和；⑤厥阴病外出少阳；⑥阳微结证；⑦伤寒解后，更发热或胸满胁痛；⑧热入血室证；⑨黄疸病，腹痛而呕吐；⑩外感热病，呕而发热者；⑪妇人产后郁冒证。可见，小柴胡汤治疗范围之广，是任何方剂所不能比拟的。临床医家，若能领悟少阳为枢之奥义，掌握小柴胡汤解郁利枢的作用，反复实践，逐渐体会，即可以执柴胡剂而治百病，起沉痾，去顽疾。因此说，小柴胡汤擅开肝胆之郁，故能推动气机而使六腑通畅，五脏安和，阴阳平衡，气血谐和，其功甚捷，而其治又甚妙。无麻桂而能发汗，无硝黄而能通便，无苓术而能利水，无常山、草果而能治疟。所谓不迹其形而独治其因，郁开气活，其病可愈。

60.大柴胡汤证

(1) 高热案

王某，男，57岁。外感后续发高热40℃，持续2天而退。此后每隔十余日必发一次，很有规律性。发热时两目昏糊，不恶寒，伴心胸痞结，大便干燥，小便色黄，舌苔黄腻。此邪热伏于少阳募原，为“瘧疟”之证。

柴胡9克 黄芩9克 大黄9克 枳实9克 半夏9克 生姜12克 白芍9克 草果3克 槟榔3克 丹皮9克

服一剂后，大便畅行3次，热退。改方为柴胡、黄芩、厚朴、知母各9克，大黄、草果、青皮各6克，槟榔3克，又服三剂后，余证全消，后追访三个月，病证未发。

(2) 自汗案

潘某，男，48岁。外感病后，遗下自汗一证，久治不愈，尤其以深秋季节更为严重。汗出多时，浸透衣被，换衣不迭。伴见胸闷，头目眩晕且胀等。舌质绛红苔腻，脉弦。

柴胡12克 黄芩9克 半夏9克 生姜9克 枳实9克 大黄9克 白芍9克 生石膏9克

服药二剂后汗出减半，头胀眩晕亦减。改方为：柴胡12克，生石膏24克，丹皮、白芍各12克，知母、栀子各9克，炙甘草6克，又服二剂，遂汗止而安。

【解说】

汗出一证，有阴虚阳虚之分，有在表在里之别。阳虚汗出必伴心悸气短，形寒畏冷；阴虚汗出多伴五心烦热，舌红少苔。若属表邪，营卫失和而汗出，则有恶风，头痛等证；若属里热，阳明之热外蒸而汗出，则有恶热，蒸蒸发热之苦。唯此少阳病汗出，一般不大引人注目。从前列小柴胡汤治盗汗案，及此大柴胡汤治自汗案可见，汗出证属于邪在少阳者亦不少见。因此，临床上应多留心于此，方能不废柴胡汤治自汗、盗汗之法。

(3) 惊狂案

李某，女，20岁。新产后20天，因与邻居争吵，气恼之余而发神志之病。精神失常，骂人摔物，或瞋目握拳，口中念念有词，时或叫唱，

烦躁不安，已有七个昼夜目不交睫。曾服“冬眠灵”等药亦未能奏效。来诊时双目发直，两手躁动无休止。询知大便数日未解，左侧腹痛拒按，恶露亦停。唇舌红绛，苔黄腻，脉弦滑有力。此气火交郁，兼有瘀滞，肝胃皆实之证。

柴胡12克 大黄9克 枳实9克 半夏9克 生姜9克 桃仁12克 赤芍10克 丹皮12克 山栀12克 郁金10克 菖蒲10克 香附10克 陈皮10克 竹茹10克

服药仅一剂，则泻下黏腻黑色粪便甚多，当夜即能入睡，呼之不醒。逾一昼夜而寤，神志恢复正常，恶露又下。

（4）鼻衄案

赵某，女，13岁。患鼻衄不止，伴见大便秘结，胸胁苦满，口苦善呕。舌苔黄，脉弦滑。肝胃火盛，迫血上行，治宜泻肝胃之火。

柴胡9克 黄芩6克 白芍12克 枳实6克 大黄6克 丹皮12克 玄参12克 牡蛎12克

服药一剂，大便畅通而衄止。

（5）胁痛案

李某，女，54岁。右胁疼痛，旁及胃脘，痛势剧烈难忍，满床乱滚，大汗淋漓，只有注射“杜冷丁”后才能勉强止痛一时。其人形体肥胖，面颊红赤，口苦泛恶，不能饮食，大便已4天未解，小便黄赤涩痛。舌体红绛，苔根黄腻，脉沉滑有力，西医确诊为胆囊炎，但不排除胆石症。中医认为病位在肝胆，气火郁结，肝气横逆，傍及胃肠，腑气不利，故大便秘结。六腑以通为顺，气火交阻凝结，所以疼痛剧烈难忍。

柴胡18克 黄芩9克 半夏9克 生姜12克 大黄9克 枳实9克 白芍9克 郁金9克 陈皮12克 牡蛎12克

药煎成后，一剂分温三次服下。一服后痛减；再服后大便通行，心胸得爽，口苦与恶心皆除；三服尽则疼痛止。

（6）胃脘痛案

贾某，男，68岁。患胃溃疡并发急性胃穿孔，胃脘疼痛，呕吐酸水，夹杂咖啡色物。大便已四日未解，心烦口苦，不进饮食。医院决定做手术，但病人之子恐年迈多险而拒之，转请中医治疗。脉弦滑而大，舌苔黄厚而腻。此肝火郁于胃中，火邪伤及阴络所致。

柴胡12克 黄芩9克 半夏9克 生姜12克 大黄6克 枳实9克 白芍9克 大枣4枚

只服一剂，大便泻下黑色与黏白之物，胃痛骤减，呕吐亦止。然后用益胃阴之法调理数剂而安。

（7）心下坚满案

某女工，患心下坚满，短气胸闷，须太息而后舒，心烦恶心。曾多次服用舒肝调胃之药，但效果不明显。舌边红，脉沉弦有力。此因肝胆气郁，日久化火，兼挟痰饮所致，非大柴胡汤不能克之。

柴胡12克 黄芩6克 半夏9克 生姜15克 枳实6克 白芍9克 大黄6克 大枣7枚

药成后分温三服，尽剂后则坚满诸证皆消。

（8）肠痛案

李某，女，36岁。患慢性阑尾炎急性发作，右侧少腹疼痛，伴见低热不退，胸胁苦满，月经衍期未至，带下极多。舌质绛，苔黄白夹杂，脉沉滑。证属肝胆气郁，湿毒与血相结。

柴胡15克 黄芩6克 大黄9克 枳实9克 赤芍15克 丹皮15克 桃仁15克 冬瓜仁30克 苡米30克 茯苓30克 桂枝6克 苦参6克

服药二剂后，少腹疼止，热退，月经来潮，再稍加调理而愈。

【解说】

大柴胡汤为仲景群方中开郁泻火之第一方，由小柴胡汤去人参、甘草，加大黄、枳实、芍药而成。大黄配枳实，已具承气之功，以泻阳明实热；芍药配大黄，酸苦涌泄为阴，又能于土中伐木，平肝胆之火逆；枳实配芍药，为枳实芍药散，能破气和血。最妙之处在于重用生姜，既能和胃止呕，又能以其辛散上行之性牵制大黄峻猛速下之力，所以具有载药上行以和胃气的作用。

综观《伤寒论》113方，具有“载药上行”作用的共有六个方剂：三物白散，栀子豉汤，瓜蒂散，大陷胸丸，调胃承气汤及大柴胡汤。三物白散中用桔梗，能引峻攻之品上入至高之分，使之达到攻下寒实的作用；栀子豉汤、瓜蒂散中用豆豉，能轻宣上行，以尽驱胸中之邪；大陷胸丸用白蜜，恋硝、黄、甘遂之功于上，峻药缓用，以尽下高位之实邪，确有载药上浮之功；调胃承气汤用炙甘草，缓恋硝黄，如船载铁石入江而不沉，所以《长沙方歌括》说“调和胃气炙草功”。可见，六个方剂用药不同，治疗作用亦不同，但其用舟楫之品载药上浮则同，这样，既能尽去邪气，又能顾护正气不被峻药所戕伐。后世医家专以桔梗为舟楫之使，殊不知“载药上浮”有多种形式，决不能以药而论，而应该以证而论，务以契合病机，方能得其要领。因病机之差异，上浮之药也是彼

此不能代替的。例如桔梗用在三物白散中以作舟楫，非常合拍，如果将其用在瓜蒂散或栀子豉汤中，不但格格不入，无功效可言，反能导致不良作用。又如大陷胸丸用白蜜非常对证，若改用甘草，则与甘遂“相反”而同室操戈，改用桔梗则泻下必速，改用豆豉则必走津助燥。所以，大柴胡汤中用生姜，既能使大黄之泻下不至于极，又避开少阳病不可下之禁，而使枢机畅利。

大柴胡汤既能开肝胆之郁，又能下阳明之实，既治气分，又调血分。临床上属于肝胆胃肠不和，气血凝滞不利的病症比较多见，因此，本方常用来治疗多种急腹症及其他一些消化道病变，如急性胆囊炎，胆石症，急性胰腺炎，溃疡病穿孔，急性阑尾炎或慢性阑尾炎急性发作等，只要脉证相符，功效卓著。临床经验证明，凡属气火交郁的实性病变，其腹胀或腹痛往往都比较急迫剧烈，此时就可用大柴胡汤治疗，尤其是疼痛偏于胁腹两侧者，效果更佳。

61.柴胡桂枝汤证

(1) 鼻渊案

钟某，男，21岁。患慢性鼻窦炎5年，每因外感而诱发，发则头痛，流涕黄浊而腥臭。此次发病已两周，饮食及二便皆正常，但恶风寒。舌质淡苔白，脉弦。《素问·气厥论》说：“胆移热于脑，则辛^颧鼻渊，鼻渊者，浊涕下不止也。”恶风寒者，营卫不和之故。

柴胡12克 黄芩9克 桂枝9克 白芍9克 生姜9克 半夏9克 党参6克 大枣5枚 炙甘草6克

服三剂药后复诊，诉服药后覆被须臾，即周身微有汗出，每次服药都如此，三剂服尽，则头痛、浊涕霍然大减。五年来服各种中西药都没有这样好的效果，因于上方内加黄连3克，续服三剂而愈。

(2) 皮肤发凉案

李某，女，48岁。所患之证颇奇，周身酸疼时，皮肤有如涂清凉油一般发凉透肤，伴见胃脘发胀，以进食后更甚。心悸，大便干，舌红苔白。

柴胡12克 黄芩9克 桂枝6克 白芍6克 半夏9克 生姜9克 炙甘草6克 瓜蒌30克

服药后腹中作响，矢气甚多，共进六剂，皮肤发凉及胃胀悉除。

【解说】

柴胡桂枝汤是小柴胡汤与桂枝汤的合方，既具小柴胡汤解郁利枢之功，又兼桂枝汤调和营卫，调理气血阴阳之能。临床上多用于以下几种病证：①少阳病证与太阳病证同时并见，即胸胁苦满或胁背作痛，而又见有发热恶寒，或肢节烦疼等，用本方治疗效果甚佳；②肝气窜证，发病特点是患者自觉有一股气在胁肋胸背，甚至四肢流窜，或上或下，或左或右，或前或后，凡气所窜之处，则觉疼痛或胀满，用本方有特效；③本方去大枣、人参，加鳖甲、牡蛎、红花、茜草等软坚化瘀之药，治疗慢性肝炎，肝脾肿大及早期肝硬化等，出现腹胀，胁痛如针刺，面色黧黑，舌质紫黯或有瘀斑等证，坚持久服，常有良效。

值得一提的是，张仲景在小柴胡汤方后注中说：“若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两……若不渴，身有微热者，去人参，加桂枝三两；温

覆微汗愈”。可见，仲景原本就有柴胡加桂枝汤以调外之法，又有柴胡加芍药汤以和内之法。若将此二法合而为一，则成内外俱调的柴胡桂枝汤法。这样，一法之中，三法存焉，三法各有差别，因而其临床运用也各有不同。柴胡加桂枝汤，临床多用来治疗少阳证而又兼有心悸，气上冲等证；柴胡加芍药汤，临床多用来治疗少阳病而兼肝脾不和，血脉不利之腹中疼痛，且有拘挛之感，按其腹肌如条索状，此证尤其多见于妇女月经不调及痛经者。兹各附案例一则于下，以见其用。

附一：柴胡加桂枝汤证

张某，女，59岁。素有风湿性心脏病，初冬外感，发热恶寒，头痛无汗，胸胁苦满，心悸，不时有气从心下上冲咽喉，则烦悸不宁。

柴胡12克 黄芩6克 桂枝9克 半夏9克 生姜9克 大枣5枚 炙甘草6克

三剂而诸证皆安。

附二：柴胡加芍药汤证

郝某，女，22岁。肝气素郁，经常胸胁发满，胃脘疼痛，每届月经来潮之时则小腹拘挛疼痛。

柴胡12克 半夏9克 生姜9克 党参6克 白芍9克 大枣6枚 炙甘草6克 当归尾6克 泽兰9克

连服六剂而愈。

62.柴胡桂枝干姜汤证

（1）胁脘疼痛案

郑某，女，62岁。右胁及胃脘部剧烈疼痛已5天，大便溏泄，每日二三次，舌质淡苔薄，脉弦。

柴胡12克 黄芩6克 桂枝6克 干姜6克 花粉12克 牡蛎12克 炙甘草6克

服药三剂后，疼痛大减，大便已成形，每日一次，上方续服三剂而愈。

（2）腹胀案

刘某，男，35岁。因患肝炎住某传染病医院，最突出的症状是腹胀特别明显，尤其以午后为严重，坐卧不安。伴大便溏稀不成形，每日二三次，小便反少，且口渴欲饮。舌质淡嫩苔白滑，脉弦缓而软。此肝病及脾，中气虚寒，而又肝气不疏，所以大便虽溏而腹反胀。

柴胡10克 黄芩6克 桂枝6克 干姜6克 花粉12克 牡蛎12克 炙甘草6克

连服六剂后，腹胀消，大便也转正常。

（3）慢性腹泻案

齐某，男，42岁。患慢性溃疡性结肠炎已近5年，腹痛腹泻，午后为甚，大便有黏液，轻则每日3~4次，重则每日7~8次，往往因过食生冷或精神紧张而加重。伴见：口苦心烦，失眠，口渴欲饮，不思饮食，小便短少，下肢肿胀。舌边尖红，苔白厚，脉弦而缓。证属太阴脾寒而肝胆郁热。

柴胡10克 黄芩6克 桂枝12克 干姜12克 花粉12克 牡蛎20克 炙甘草10克

服药七剂后，腹泻减为每日1~2次，腹痛减，精神好转。续上方加党参9克，又连服二十余剂，诸症皆消。后经纤维结肠镜检查，溃疡愈合。

（4）心悸案

史某，女，60岁。三年前确诊为冠心病，近两个月来心悸明显，心电图提示为频发性室性早搏。症见：心悸心烦，手指麻木，伴口苦口干，不欲饮食，两胁疼痛连及后背。大便稀溏，每日三四次，午后腹胀，小便不利。舌质红苔白滑，脉弦缓而结代。

柴胡12克 黄芩6克 干姜6克 桂枝10克 花粉10克 牡蛎30克 茯苓30克 炙甘草12克 四剂。

服药后心悸明显减轻，便溏、腹胀等证也减。上方又服七剂后，诸证皆消，心电图检查提示大致正常。因改为苓桂术甘汤加太子参以善其后。

（5）消渴案

刘某，男，48岁。患糖尿病已3年，又有肝炎及胆囊炎病史。症见：口苦口干，渴欲饮水，饮而不解渴，查尿糖（++++）。伴有胸胁满而心烦，不欲食，食后腹胀，大便稀溏，每日二三次。舌质红，苔薄白，脉弦。

柴胡14克 黄芩10克 干姜10克 桂枝10克 花粉15克 牡蛎30克 炙甘草10克

服药七剂后，口渴明显减轻，口苦消失。上方加太子参 15克，又继续服用近二十剂后，诸证全部消失。复查尿糖（—）。

【解说】

柴胡桂枝干姜汤是小柴胡汤的一个变方，治疗邪传少阳，枢机不利，三焦气寒，津液不布而见“往来寒热，胸胁满微结，心烦，渴而不呕，小便不利，但头汗出”等证。但从临床上看，属于少阳气郁而三焦气寒的病证并不很多见，然而这并不妨碍本方在临床上的广泛运用。从本方的药物组成来看，由于内含甘草干姜汤及桂枝甘草汤两个基本方，所以，常用来治疗少阳气郁而兼脾阳不足或心阳不足之病变。

甘草干姜汤是温补中阳的基本方子，理中汤和四逆汤都是在此方基础上加味而成。从这个意义上看，柴胡桂枝干姜汤既能清解少阳胆热，又能温补太阴脾寒，所以用来治疗少阳胆热兼有太阴脾寒证，简称“胆热脾寒”，常能获令人满意的疗效。胆热脾寒的临床特点是既有胸胁苦满或疼痛，口苦咽干，心烦等证，又有脘腹胀满，大便稀溏，不欲饮食等证。这与大柴胡汤治疗少阳病而兼阳明腑实对照而言，恰有寒热虚实鉴别的意义。临床上这种“胆热脾寒”的情况多见于慢性肝胆疾患中，由于长期服用清利肝胆之药而导致脾气虚寒，或日久杂治以致寒热错杂，舍此方则无他法，用此方则无不有立竿见影之功，真可谓是万世之绝方。

桂枝甘草汤是温通心阳的基本方，《伤寒论》中凡是取温补心阳的方剂都以此作为基础，如桂甘龙牡汤、苓桂术甘汤等。所以，从这个意义上讲，柴胡桂枝干姜汤又具有清解少阳胆热和温补心阳的双重治疗作用。因此，临床上可以用来治疗少阳气郁而兼心阳不足的病证。心主血

脉，心阳不足则无力运行血脉，因而常表现为头晕，肢体麻木，或心下逆满，气上冲心等症状，这为临床治疗心脑血管病变又开辟了一条新的途径。

又附：头晕案

王某，男，68岁。患头晕已数年，近期加剧，脑电图提示脑血管供血不足。伴有口干苦，心烦，偶或右胁作疼，大便稀溏，每日二次，有下坠感，绕脐腹痛，下肢怕冷。舌质胖红，脉弦。服用柴胡桂枝干姜汤原方加白芍15克，七剂后，大便转为正常，不下坠，胁腹疼痛止，头晕亦随诸证而有明显减轻。上方去白芍，续服七剂而安。

63.柴胡加龙骨牡蛎汤证

(1) 癲痫案

尹某，男，32岁。患癲痫病，平素头晕，失眠，入寐则呓语不止。胸胁苦满，自汗出而大便不爽。癲痫时常发作，望其人神情发呆，面色青白，舌质红苔白而干，脉沉弦。头晕，胸胁满而脉弦，证属少阳无疑。入夜梦呓犹如白昼谵语，自汗出又不恶寒，复兼大便不爽，已露阳明腑热之机。此病得于惊恐之余，又与肝胆之气失和有关。《伤寒论》说：“胸满烦惊……谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之”，与此证极为合拍。

柴胡9克 黄芩9克 半夏9克 生姜9克 茯苓9克 桂枝6克 龙骨9克 牡蛎18克 大黄6克 铅丹4.5克 大枣6枚

服一剂后，呓语止而胸胁满去。精神好转，但见气逆，欲吐不吐之状，加竹茹、陈皮各10克，再服二剂而证全消。此后癲痫未发。

(2) 小儿舞蹈症案

张某，男，9岁。患小舞蹈症已二年，久治不愈。手足舞蹈，躁动不安，口中叫喊，讴哑不可辨。入夜少寐而烦，但神识尚清，能识父母，知好恶，非癲非痴。脉弦滑，舌红苔黄腻。病属肝胆气火交进，痰热交郁而阳气不潜。

柴胡12克 黄芩9克 半夏9克 生姜9克 大黄6克 茯苓9克 龙骨12克 牡蛎12克 铅丹4克 菖蒲6克 郁金9克 胆星6克 竹沥30克

服药四剂后，手足躁扰得安，夜能安寐，症状显著好转。遂去铅丹改为生铁落，再进三剂，其病竟愈。

(3) 肢体震颤案

刘某，女，38岁。素有肢体颤抖疾患，1976年因悼念周恩来总理过哀而病又发作，较前更为严重。头摇肢颤，观之令人神乱，曾服平肝息风之品而效不明显。因其人大便秘，胸胁胀，舌质红，苔黄白相兼，脉弦劲有力，辨为肝胆气郁而化火，火动则神摇，而风从内生。

柴胡12克 黄芩9克 半夏12克 生姜9克 桂枝6克 党参6克 茯苓12克 大黄6克 龙骨18克 牡蛎18克 铅丹3克 大枣5枚

服药仅三剂，振摇顿止，其证转安。

【解说】

本方由小柴胡汤去甘草，加桂枝、茯苓、大黄、龙骨、牡蛎、铅丹而成，具有开郁泄热，镇惊安神之功，用治少阳不和，气火交郁，心神被扰，神不潜藏而见胸满烦惊，谵语，心烦，小便不利等证。观《伤寒论》中所说“烦惊”、“谵语”，皆属神志为病，所以临床上常用本方治疗因肝胆气郁所致的精神分裂症，癫痫，小儿舞蹈症等，往往有效。应该注意的是，铅丹有毒，使用时必须用棉纱布包裹入煎，用量切勿过大，一般不超过5克，而且不要连续长期使用，以免造成蓄积性铅中毒。如果不用铅丹，亦可用生铁落代之。

64.小建中汤证

(1) 产后腹痛案

李某，女，38岁。产后失血过多，患腹中疼痛，痛时自觉腹皮拘急向里抽动，须用热物温暖方能缓解。舌质淡嫩而苔薄，脉弦细。血虚不能养肝，肝气急则横逆犯脾，脾主大腹，所以腹中拘急疼痛而遇寒更甚。

桂枝10克 白芍30克 当归10克 生姜9克 大枣7枚 炙甘草6克 饴糖40克
服药三剂而痛止。

(2) 胁痛案

范某，男，42岁。素有肝炎病史，两胁疼痛而以右胁为甚，经服柴胡剂而不效。其人不欲饮食，体疲腹胀，心悸气短，面色青黄不泽。舌质嫩苔薄白，脉弦而缓。证属土衰木盛，少阳病而兼太阴气血不足，按理当先建其中，而后斟用柴胡汤方为得法。

桂枝9克 生姜9克 白芍18克 大枣12枚 炙甘草6克 饴糖30克

服药三剂而诸证大为减缓，患者自认为是向来所没有的效果，于是上方又进三剂，胁痛竟止。

【解说】

小建中汤是在桂枝汤调和脾胃，调和气血阴阳的基础上，倍用芍药酸甘益阴以柔肝，加用饴糖甘温补中以缓急。所以，本方在补益脾胃之中兼能平肝胆之气，又能缓解筋脉之拘急，小建中汤在临床上不但能够治疗由于脾胃虚弱，气血不和，阴阳失调所致的心中悸而烦，腹中急痛等证，还可以治疗由于肝胆气机不利所致的胁痛。《内经》说：“肝苦急，急食甘以缓之。”小建中汤属于甘温补益之剂，能健脾气以化气血，肝胆得阴血濡养则气柔而条达，所谓培土即可以制木的道理就在于此。根据临床经验，治疗因肝胆疾患导致脾气虚弱而见有肝脾证候者，可以先服小建中汤，然后再用小柴胡汤去黄芩加芍药，则疗效更佳。

65.理中汤证

浮肿案

张某，女，44岁。患目窠浮肿，胀如卧蚕，两目流泪涓涓不止，遇见风寒或劳累时更为严重。其人面色黧黄，舌体胖大而嫩，苔薄白水滑，脉沉。泪多主于阴气内盛，阴盛则阳弱，阳虚不能行水化湿，则水湿邪气泛滥为肿。

党参9克 白术15克 干姜3克 炙甘草6克 茯苓24克 黄芪18克 砂仁3克 桔梗3克 肉桂3克 陈皮6克

服药二剂后，证情明显减轻，转用真武汤温肾利水，三剂，加服肾气丸20丸，服药尽而后肿消泪止。

【解说】

理中汤以理中焦，是治理中焦太阴脾家虚寒的主方。太阴虚寒证，或因寒湿邪气直中太阴，或因过食生冷内伤脾阳而成，脾阳虚弱，中虚不能运化，则寒湿凝滞。所以太阴虚寒以脾阳弱而寒湿盛为两大特点。理中汤能温补太阴脾阳，也能散中焦寒湿。如果中焦虚寒未能得到及时的温补，发展下去就能导致下焦肾阳不足。《伤寒论》说：“自利不渴者，属太阴也，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈”。仲景早已示人脾肾阳气互相影响的关系。本案先投理中汤加肉桂，治脾而顾及肾；后用真武汤温肾以暖脾，即取意于此。

临床运用理中汤，随证加减的方法比较多，比如兼见胃寒气逆，恶心呕吐者，加丁香、吴茱萸，名为丁萸理中汤；兼见胃寒吐蛔者，加乌梅、川椒，名为椒梅理中汤；兼见寒湿下注而腰痛肢重者，加苍术、附子，名为苍附理中汤；兼湿邪蕴郁，小便不利者，加茯苓、泽泻，名为苓泽理中汤；兼大肠湿热，虽下利但黏滞不爽者，加黄连，名为黄连理中汤等等，灵活化裁，每可取效。

《伤寒论》中还有改理中汤为理中丸一法。功用虽同，但服法很有讲究。服用理中丸治疗太阴虚寒下利证，一定要遵循“日三四，夜二服，腹中未热，益至三四丸”的服药方法。今人喜食冰制之物，即使冬日寒凉，也多有食冰糕、冰淇淋之类者，以致寒冷伤中者不少。每每服用理中丸，一日不过三丸，设若无效，则谓理中丸无功，而不知其服药不得法之故。所以，服药方法不可不深究。

又附：下利案

曾治一患儿，出生才六个月，却患下利三个月。询其致病原因，在于其母恐母乳不足而在三个月时即以牛肉汤喂之。稚弱之体，不能受肥厚之物，运化功能受损，以致下利日十余次。舌质淡嫩，苔白略腻，投以理中汤原方：党参6克，干姜1.5克，白术3克，炙甘草3克，水煎喂服，二剂而愈。

66.桂枝人参汤证

协热下利案

陈某，女，19岁。外感风寒已四五天，头身尽痛，发热恶寒，大便作泻，每日四五次，腹中绵绵作痛，曾服藿香正气散无效。脉浮弦而缓，舌苔薄白而润。此太阳病，外证未除，协热而利，表里不解，当用桂枝人参汤主之。

党参10克 干姜10克 白术10克 炙甘草6克 桂枝12克

先煮理中汤，后下桂枝，昼夜分温三服，两剂而愈。

【解说】

桂枝人参汤即是理中汤加桂枝之法。理中汤温补中焦虚寒，桂枝解散太阳表邪，属于表里同治。《伤寒论》中治疗表里同病有几个原则：一是表里俱实，或是表虚里实，应先解表，后治里，先表后里也是一般常用的方法；二是表实里虚，应先治里，然后再解表，否则表邪入里则使病情更为复杂；三是表里俱弱，则往往需要表里同治，桂枝人参汤证即属于表里俱虚的病变。所以，凡遇到表里同病的情况，一定要分清表里治疗之先后。

“协热下利”是表里同病的一种典型表现，也就是下利协同表证的发热同时出现。但这种情况又分为寒热虚实两种不同，有里热下注而下利，协同表实发热者；有里寒下利而协同表虚发热者，前者可用葛根芩连汤治疗，后者则需用桂枝人参汤治疗，这在临床上也应该辨识清楚。

67.四逆汤证

腹痛阴抽案

罗某，男，50岁。夏暑天热而汗出颇多，自觉燥热干渴。入夜又行房事，事后口渴更甚，乃持杯大口饮喝凉水。不多时便觉小腹急痛，阴茎内抽，手足发凉。次日来诊，其脉沉而弱，舌质嫩苔白。此少阴阳虚而复受阴寒之重证，急当回阳散寒以救逆。

附子12克 干姜10克 炙甘草10克 小茴香6克 萆澄茄6克

服药仅一剂，则痛止厥回而安。

【解说】

足少阴肾为一身阳气之总司，若少阴阳气一衰，则周身阳气也随之而衰。所以，当少阴真阳衰竭，证候显露时，就应速投四逆汤急温，绝不可因循观望。从本案治疗来看，患者在夏日汗多耗气之时行房，先伤其阳，复又暴饮凉水而致寒气内客厥阴经脉。厥阴经脉绕阴器而抵小腹，所以腹痛而阴抽。但从脉沉弱，四肢厥冷来看，是少阴肾阳已衰，所以急用四逆汤温回少阴真阳以救逆，加小茴香、萆澄茄入厥阴以散肝经寒邪。药证相合，故能一剂而愈。

68.四逆加人参汤证

但欲寐案

曹某，年在花甲之外，其子挟掖来诊。患者终日精神萎靡不振，昏沉嗜睡，梦其先祖老辈亡人，仍着昔时衣装迎其同归，自以为阳寿已至，言讫而泪下。诊其脉沉弱无力，舌胖苔白。此阳光不振而群阴用事，故但欲寐而梦见鬼状，属少阴虚寒证，病情虽危，急温犹可活之。

附子15克 干姜6克 炙甘草9克 人参9克

服药三剂后，曹叟精神渐增，眠睡安然，亦不复梦见昔日故人。后来改用桂附八味丸与补中益气汤，服至二十余剂，渐至康复。

【解说】

《伤寒论》说：“少阴之为病，脉微细，但欲寐也”。以此一脉一证作为辨证要点，揭示了少阴病阴阳俱虚而以阳虚为主的病理变化。脉微主阳虚，脉细主阴虚，但是“微”在前而“细”在后，则含有以阳虚为主的涵义。所谓“但欲寐”，形容病人似睡非睡，精神萎靡不振的状态。神以精为体，精以神为用。精气充实，则神态自然充沛；精气不足，则神态萎靡而衰败。少阴属肾，主蛰，为封藏之本，受五脏六腑之精而藏之。如果少阴阴阳皆虚，精气不足，自然出现“但欲寐”。本案老翁年逾花甲，精气不足，肾脏已衰，阳光不振而群阴用事，非四逆汤不能温之；但四逆汤能回少阴阳气而不能补少阴之阴气，所以加人参生津滋阴，又能大补元气。所以，四逆加人参汤用于亡阳虚脱而脉沉不起，以及阳损及阴，阴阳两伤者，最为妥当。

69.白通汤证

肢厥腹泻案

林某，男，60岁。因食冷凉之物而病腹泻，每日四五次，腹中幽幽冷痛，手足厥冷，脉沉伏欲绝，先投四逆汤，服药后腹痛似乎有所减轻。但腹泻仍未能止，脉象如故。复思《伤寒论》有“少阴病，下利，白通汤主之”之说，想来正为此证而设。

附子15克 干姜10克 葱白5茎

服药一剂，即脉起而手温，再服一剂，腹泻止而安。

【解说】

白通汤即四逆汤去甘草加葱白而成。葱白辛滑性热，专能通阳气而破阴寒，用于温阳剂中，可以疏通被郁之阳气。所以，白通汤适用于少阴寒证，阴邪太盛不但伤阳，而且抑遏阳气，以致阳气既不能固于内，又不能通于脉，处于既虚且郁的状态。这种情况与单纯的阳虚证既有共同的一面，如下利、四肢厥冷；又有不同的一面，单纯阳虚脉见微弱欲绝，而阳虚且郁则表现为脉沉伏不起。四逆汤只能回阳救逆，却不能回阳通郁。所以，临床治疗阳虚性下利肢厥而用四逆汤不效时，即可考虑改用白通汤治疗。清代医家钱潢曾说：“（四逆汤）甘草所以缓阴气之急，和姜附而调护中州；（白通汤）葱则辛滑行气，可以通阳而解散寒邪。二者相较，一缓一速，故其治也，颇有缓急之殊也”。

70.桃花汤证

下利脓血案

程某，男，56岁。患“肠伤寒”住院治疗已四十多天，仍大便泻下脓血，血多而脓少，每日三四次。伴腹痛阵发，手足发凉，神疲体倦，饮食减少。其人面色天然不泽，舌体胖大质淡，脉弦缓。此为脾肾阳虚，寒伤血络，下焦失约，属少阴虚寒下利，便脓血无疑。但因久利之后，不仅大肠滑脱不禁，而且气血亦为之虚衰，所以治疗当温涩固脱兼益气生血。

赤石脂30克（一半研末冲服，一半入汤剂煎煮）炮姜 9克 粳米9克 人参9克 黄芪9克

服三剂后脓血止；再服三剂大便转常，腹中安和，饮食增进。转用归脾汤加减，巩固疗效而收功。

【解说】

桃花汤是专门为治疗少阴虚寒下利，久病入络，由气分深入血分，以致脾肾阳虚，气不摄血的下利便脓血证而设。根据临床观察，本证一般具有以下几个临床特点：①大便稀溏，滑脱不禁，脓血杂下，但血色晦暗不泽，其气腥冷不臭，无里急后重及肛门灼热感；②伴见腹痛绵绵而喜温按；③由于久利而伤津液，所以往往小便不利。服药后，大便止则小便利，脓血除则腹痛止，是属于温涩固脱，治病求本之法。此外，本方对久痢、久泄，凡属虚寒滑脱者，皆可应用。

71.真武汤证

(1) 头痛案

李某，男，32岁。患者为汽车司机，夏日开车时，因天气炎热，常在休息时畅饮冰镇啤酒或汽水，每日无度。至秋即觉头痛，每每在夜晚发作，疼痛剧烈，必须以拳击其头部，或服止痛药片始能缓解。伴有视物昏花，病程已一月多。望其人面色黧黑，舌质淡嫩，苔水滑，脉沉弦而缓。此属阳虚水泛，浊阴上窜，清阳被蒙之证。

附子12克 茯苓18克 白术9克 生姜12克 白芍9克 桂枝6克 炙甘草6克

服药六剂后，头痛明显减缓，改服苓桂术甘汤四剂而愈。

(2) 房劳伤饮案

郝某，男，30岁。夏月行房事后，因觉燥热而饮凉啤酒近一升，至黎明时忽觉少腹疼痛拘急，不一会疼痛加剧，四肢头面冷汗淋漓，其妻陪同急请中医诊治。其人面色苍白，询知小便短少色清。两手脉皆沉，尺部脉尤甚，舌苔白润。此乃少阴阳虚寒证，水邪不化为病。

附子12克 生姜12克 茯苓15克 白术10克 白芍10克

服药一剂而安。

(3) 腹痛腹泻案

孙某，女，60岁。左上腹部隐隐冷痛如掌大，每于子夜时分疼痛发作，丑时腹泻，完谷不化，有黏液如涕，或如烂柿，腹中雷鸣，出冷汗，纳食减少。经服胃舒平、酵母片及温胃理气等中药无效。病程已有三个多月，询知病证起于天寒食冷，因体阳虚弱，以致脾肾俱寒。先用附子粳米汤，服二剂后胃痛、肠鸣减轻。再诊时告知后背恶寒而疼痛，改用真武汤温阳利水，以治寒邪。

附子15克 生姜15克 白芍10克 白术10克 茯苓15克

二剂后腹背疼痛止，恶寒轻，腹泻未作。因左胁有时作疼，是寒邪犯于厥阴，于上方中加入吴茱萸15克，又服一剂而证消。

【解说】

真武汤，又称玄武汤。玄武为北方镇水之神，因本方有扶阳祛寒镇水之功，所以名为真武汤，用于少阴阳虚有寒，水气不化等证。《伤寒论》说：“腹痛，小便不利……此为有水气”，指出了本证的病机关键所

在。阴虚阳亢者多动风，而阳衰阴盛者每多动水，这是疾病发生发展的一个基本规律。阳虚动水，一般用苓桂剂进行治疗，如果病及于肾，阳气虚衰，心悸头眩，站立不稳，振振欲擗地，则必须用真武汤治疗。服用真武汤后，肾阳得温，而水气犹未能尽化，则又可用苓桂剂温药和之。

72.黄连阿胶汤证

（1）失眠案一

张某，男，25岁。心烦意乱，尤其以入夜为甚，难以睡眠，常觉居室狭小，憋闷不堪，而欲奔赴室外。舌尖红赤起刺如草莓，脉数。此乃心火燔烧而肾水不能上承，以致心肾不能相交，火盛于上，水亏于下，形成水火失济，阴阳不和之证。

黄连10克 黄芩6克 阿胶10克 白芍12克 鸡子黄2枚 竹叶6克 龙骨12克 牡蛎12克

服一剂烦减，二剂寐安。

（2）失眠案二

孙某，男，22岁。患者心烦面赤，头上汗出，夜寐不实。伴头目眩晕，耳鸣，口干欲饮，小便黄，舌质红绛而少苔，脉细数，证属阴虚火旺。

当归10克 黄连10克 黄柏10克 黄芩6克 生地12克 熟地12克 黄芪12克 牡蛎18克

三剂后汗止，面赤减，但心烦郁闷更甚，夜难入眠。此因归芪甘温，汗虽止而心火未清，所以难以入眠，乃变泻火固表为清心滋阴之法，用黄连阿胶汤治之。

黄连6克 黄芩6克 阿胶10克 白芍10克 鸡子黄2枚

服药三剂，恬然入睡。

【解说】

黄连阿胶汤是治疗少阴阴虚火旺，心肾不交，水火失济之方。少阴包括了手少阴心与足少阴肾。心主火而位居于上，肾主水而位居于下，在正常的生理情况下，心火要不断下降以温肾水，使肾水不寒；肾水亦需不断上承以济心火，使心火不亢。心肾借助经脉的联系与沟通，使得上下水火交济，以维持人体阴阳的相对平衡状态。如果少阴肾水亏虚，心火无制而上炎，就会导致心肾不交，水火失济的病理状态。这种病理状态所产生的最常见的病证就是“心中烦，不得卧”。心烦不得卧寐是说心烦之证为重而并非一般，其舌脉的特点是：舌质红绛少苔或光绛无苔，甚则舌尖红赤起刺状如杨梅，脉细数或弦数。黄连阿胶汤中芩、连

苦寒以泻心火；鸡子黄、阿胶血肉有情之品以滋肾水；芍药与芩、连相配，酸苦涌泄以泻火，与鸡子黄、阿胶相配，酸甘化液以滋阴，同时还能敛热安神以和阴阳。因而全方具有滋阴泻火，交通心肾之功。但临床运用时，一定要注意煎服方法：一是阿胶烊化后兑入汤药中；二是鸡子黄不可与药同煎，应当等待去滓稍凉时纳入汤中，搅令相得服之。

（3）更年期综合征案

程某，女，47岁。天癸将竭，已值更年期，患病至今已有三年多。每次发病开始时便觉心中烦乱，莫能言状，继而周身烘热难忍，少顷则蒸蒸汗出，汗出后则热去而安，每次发作约5分钟。近来发作频繁，每半小时左右发作一次，不分昼夜，夜不能安寐，伴见大便或干或稀而不调。舌质红绛少苔，脉弦按之无力。

黄连12克 黄芩3克 阿胶12克 白芍6克 鸡子黄2枚

服药五剂后显效，病发次数减少，每天发作仅4~6次，夜寐转佳。改用“壮水之主以制阳光”，投三甲复脉汤，又服十余剂而愈。

【解说】

观本案病证，先心中烦乱，再周身烘热，最后汗出而退，如此循环不已者，属于阴不制阳，阴阳失调的病理反映，多见于妇女更年期。诊治之法，以调和阴阳为原则，主要从三个方面入手：一是从肾调治，凡见舌质红绛少苔，心烦而不得寐者，用黄连阿胶汤滋阴降火，交通心肾；二是从脾胃调治，凡见舌质淡而苔白，纳食不香者，用桂枝汤调和脾胃以营卫阴阳；三是从肝胆调治，凡见舌苔白腻，心悸胆怯，头晕呕恶者，用温胆汤清利肝胆以化痰热。

黄连阿胶汤虽以滋阴降火为主，但对于阴虚较甚的患者，若服药后火热证已去，则应该减少芩、连的用量，或去掉芩、连而加强滋阴养液的作用。因为阴虚火旺证的关键是在于阴虚不能济火，如单纯用滋阴或单纯用降火的方法都无济于事，二者必须同用。待其火势已减，如果再用芩、连则恐其苦寒反而化燥成火，所以应当减量或去之，而增加滋阴之剂以防火势再起。在这种情况下，最佳的方剂选择就是三甲复脉汤。三甲复脉汤从黄连阿胶汤演化而来，无芩、连苦寒化燥之弊，有三甲填补真阴之功，壮水之主以制阳光，是少阴阴虚证的治本之法。

（4）咽干案

赵某，男，49岁。患慢性肝炎数年，现症以口中干涸乏津为主，口腔有麻木不适感，舌体硬而有蹇缩之状，舌尖红赤，脉沉弦。曾用益胃汤、白虎汤加花粉等治疗均无效。证属阴虚少津无疑，为何治疗无效？于是又仔细询问其证，才得知其尚有心中烦，夜寐不安等证，改用黄连

阿胶汤治疗。

黄连6克 黄芩3克 阿胶10克 白芍10克 鸡子黄2枚

服药仅三剂，则口腔湿润，干渴不复存在。

【解说】

本案以口中干涸为主诉，先用益胃汤、白虎汤加花粉等治疗反而无效，原因就在于辨证时没有抓住心烦不得寐这一主证，因而就忽视了肾水不足复加心火上炎这一病理变化。所谓主证，也就是辨证要点，这是决定全局而占主导地位的证候，直接反映了疾病的基本性质及规律，因而也是最可靠的临床依据。只有抓住主证，才符合辨证的思维方式，才能进一步认清兼证与变证，分清辨证的层次，从而使辨证的程序井然有序。因而，抓住主证是临床取得疗效的关键所在。但是，临床上要做到娴熟地抓住主证并非容易之事，因为病人的主诉有时并非辨证所需的主证，这就容易造成错觉。所以首先要求医者多读书，读好书，把每一种病证，每一个方剂的主证，及其主要病机熟记于心中；其次，还要在临床上多实践，多揣摩，反复印证，才能提高抓主证的水平。

（5）月经淋漓案

陈某，女，25岁。月经淋漓不断，往往前次月经未尽，下次又潮，伴见面色萎黄，疲乏无力，心烦难寐，或偶尔得眠，又乱梦纷纭，反增疲倦。曾多次服用温补涩血之剂，六脉滑数，舌红尖赤，心火上炎，无水以制，阳亢不能入于阴中，故而心烦难寐；心主血脉，心火盛则血不安经，因此月经淋漓不止。然而心火上炎，实由肾水不滋所致。

黄连10克 黄芩6克 阿胶10克 白芍10克 鸡子黄2枚

服药五剂，则血止寐安。

【解说】

黄连阿胶汤治疗月经淋漓、崩漏而有阴虚火旺见证者，疗效很好。《素问·评热病论》说：“胞脉者，属心而络于胞中”。如果肾水亏而不足以上济心火，心火却移热于胞宫之中，逼迫胞中血溢而不安于经脉之中，则发生经淋崩漏之证。经血属阴类，经血淋漓不止，则更伤阴气，阴气伤则火更炽，从而导致一种不良的循环。通过滋阴降火的方法，而重新恢复阴阳的平衡状态，从而达到治疗的目的。

（6）腰腿寒冷案

李某，男，43岁，1978年10月，在无明确诱因的情况下，自觉两下肢发冷，并逐渐向上发展至腰部，向下至足心，寒冷之状如赤脚立于冰雪之中，寒冷透骨，并有下肢麻木，有时如虫行皮中状，以后寒冷又进

一步发展至两胁之间。伴有阳痿不举，小便淋沥。一年半来，曾在北京各大医院，经中西医多方治疗均无效。视其双目有神，面色红润，舌质绛，脉弱略数。初按肝胆气郁，阳气不达之阳郁厥证论治，投四逆散加黄柏、知母无效。再诊时，询知有心烦寐少，多梦，身半以上汗出。此当属黄连阿胶汤证，但下肢为何厥冷？因而想到《伤寒论》中曾说：“太阳病二日，反躁，凡熨其背而大汗出……故其汗从腰以下不得汗，欲小便不得……足下恶风”，以及“微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦逆……因火而盛，病从腰以下必重而痹”。由此可见，凡火热盛于上者，必痹于下，而形成上下阴阳格拒之势。本证火气独在上，故心烦不得眠而身半以上汗出；阳气不下达，故腰腿以下厥冷。

黄连9克 黄芩3克 阿胶9克 白芍6克 鸡子黄2枚

服药三剂后，下肢寒冷麻木等明显减缓，心烦汗出等证也大有好转。上方加丹皮6克，并同时服用知柏地黄丸而愈。

【解说】

本案辨证分析较为详细，在此无需多语。但是，细心的读者会注意到，前述附子泻心汤证宋某一案，与本案病证极为相似，为什么彼用附子泻心汤而此则用黄连阿胶汤？确实，二案证候表现皆为上热下寒，上下水火失交之象。但是附子泻心汤证的形成是以真阳不足为前提，热是真热，寒是真寒，所以，必须用附子以温下寒，用三黄以清上热；而黄连阿胶汤证的形成则是以真阴不足为前提，由于心火独盛于上而阳气不能下煦，所以用滋阴降火的方法治疗。虽然此二者均出现上热下寒的证候表现，但通过四诊合参，就不难发现二者的不同之处。附子泻心汤证由于以阳虚为前提，所以往往见有大便稀溏，形寒汗出，舌质淡嫩或黯红，舌体胖大，苔白或苔白润；而黄连阿胶汤证由于以阴虚为基础，所以往往可见口咽干燥，小便短赤，舌质红绛或光绛无苔，舌体瘦小等证。

73.猪苓汤证

(1) 腰痛案

边某，女，23岁。1967年曾患左肾积水而经大同市某医院手术治疗。至1975年，右肾区常常疼痛，经北京市某医院同位素扫描后发现：右肾内梗阻并有轻度积水。现症：腰痛，小便不利，大便不爽，口咽发干，伴有痛经。舌质红绛，苔水滑，脉沉细弦。辨为阴虚有热而与水相结。

猪苓10克 泽泻15克 茯苓18克 滑石18克 阿胶10克 瓜蒌皮12克 紫苑10克 青皮10克 麦冬24克

服五剂，小便利，大便正常，腰痛减轻。上方加杏仁、枇杷叶各10克，又服五剂疼痛亦止。

(2) 尿血案

刘某，女，35岁。患慢性肾炎，腰痛，小便不利，尿血，眼睑浮肿。尿检：蛋白(+++)，红细胞满视野，舌质红绛苔净，脉细数。

猪苓10克 茯苓30克 泽泻15克 滑石18克 阿胶10克 旱莲草30克 女贞子10克

服药三剂后，腰痛减轻，小便利。尿检：蛋白(+)，红细胞(+)。转方改用：桑寄生30克，山药24克，茯苓、杜仲、狗脊、枸杞子、补骨脂各10克，又服四剂，腰痛止，肿消，尿检正常。疏右归丸一料巩固。

(3) 产后下利案

崔某，女，35岁。产后患下利，前医作脾虚论治，曾服不少补脾药而无效。症见：下利而口渴，舌绛而苔薄黄，脉沉略滑。初以为厥阴下利，投白头翁汤不效。细询后，知有夜寐不佳，咳嗽而下肢浮肿与小便不利等证。

猪苓10克 茯苓10克 泽泻10克 滑石10克 阿胶10克

连服五剂后，小便畅利，腹泻随止，其他各症亦消。

(4) 眩晕案

张某，女，39岁。头目眩晕如坐舟车，且头沉项强，舌绛苔白，脉沉滑。西医诊断为“梅尼埃综合征”。始用温胆汤加味以化痰热，药后无

效。仔细询问后知有心烦眠差，小便不利等水证，改用猪苓汤。

猪苓12克 茯苓12克 泽泻12克 滑石12克 阿胶10克

上方服五剂后，证情明显好转，去阿胶加桂枝、白术、太子参等，又服六剂而安。

（5）头痛案

患者为德国男性青年，有慢性肾炎病史。近三个月屡发头痛，或轻或重，伴小便不利，舌质红苔滑腻，脉沉。此下焦水热上冒清阳，欲解其上，当利其下。

猪苓15克 茯苓30克 泽泻15克 滑石15克 阿胶10克

前后共服十余剂，小便畅利而头痛止。

【解说】

猪苓汤是治疗少阴阴虚水停，水热互结的一首名方。少阴肾脏为主水之脏，对人体内的水液代谢起着十分重要的调节作用。肾主水的功能包括了两方面的作用，即肾阴与肾阳的作用。众所周知，少阴阳虚，肾气不能温化水液，能够导致阳虚水泛证，用真武汤治疗。然而，肾之所以能够主水，却不仅是阳气的一方面作用。事实上，肾主水的功能是肾气对水液代谢所起的作用，即所谓气能化水，气能行水。而肾气的产生与强弱，则取决于肾阴与肾阳两个方面。肾阴是产生肾气的物质基础，而肾阳则是肾气的功能反映。可见阴阳二气互为体用，以促进肾气的生成并维护其主水的功能。因此，无论是肾阳虚或肾阴虚，都能导致肾气的虚弱，从而减弱其主水的功能，使得水液内停而为邪。

肾阴不足所产生的水液病变在病理上与肾阳虚弱所导致的水液病变有所不同。一方面阴虚导致停水，另一方面肾阴虚不能上济心火，又能产生内热，停水与内热相互搏结，则形成了水热互结这一特殊的病理结果。所以，临床表现既有水邪为患的小便不利，咳而呕渴，或下利等证，又有阴虚内热的心烦不得眠。除此之外，腰部酸痛和尿血亦是该病证的两种常见症状。

需要指出的是，黄连阿胶汤证与猪苓汤证均属少阴阴虚为主的热化证，由于二者病机偏重不同，所以治疗方法也不同，但又由于二者都是以肾阴虚为基础，所以，在病机、病证上存在着相互转化的条件。

74.猪肤汤证

咽痛案

某女，20岁。因歌唱过度而致咽喉疼痛，声音嘶哑，屡服麦冬、胖大海之类药物无效，适值演出之时，心情十分焦急。视其舌质红而少苔，脉细，辨为肺肾阴虚，虚火上扰之“金破不鸣”证。

净猪肤半斤

上一味，熬汤成后调入鸡子白，徐徐呷服，服药尽，则咽痛止而音哑除。

【解说】

猪肤汤治疗少阴阴虚，虚火上扰所致的咽痛证，疗效甚好，只可惜现今临床上很少采用此法，动辄用麦冬、沙参、玉竹、生地及蝉衣、玉蝴蝶之类，非但不效，反而因其滋腻而生痰湿。猪肤即猪皮，以去尽皮下肥油者为佳。使用时将猪皮洗净，置水中文火慢熬，待其皮烂能嚼之时，或调入鸡子白，徐徐呷服，或加白蜜、熟米粉调和，分温服之。此物能滋润肺肾，清少阴浮游之火，其性虽润，却无滑肠之弊，清热润燥而不滞腻，用来治疗阴虚而热不甚，又兼下利脾虚的虚热咽喉疼痛，最为相宜。

75.半夏汤证

音哑案

丁某，女，36岁。患音哑、咽喉肿痛半年多，伴咽喉痞闷，大便偏干，小便自调。舌苔薄白润滑，脉浮。证属寒遏阳郁，经脉不利，治当散寒开结。

半夏15克 桂枝12克 炙甘草6克

服药六剂后，咽喉肿痛及痞闷明显减轻，已能发出声音但不清晰。上方加竹茹6克，又服六剂后，音哑已除，说话声音如常人。

【解说】

咽喉部位的病变是临床上常见病之一，但治疗往往缺乏令人满意的疗效。究其原因，多属辨证思路单一，以及选用方药不当。《伤寒论·少阴病篇》对咽喉病论述甚详，辨证从寒热虚实各个方面着手，给人以很大的启迪，因此，研究《伤寒论》中各种咽喉病变的证治，无疑将有助于提高这方面的临床疗效。半夏汤是其中治疗寒凝咽喉，经脉不利的一首方剂，具有散寒开结，化痰通痹的功效，专门用以治疗寒性的咽喉疼痛及音哑，临床上常将本方与麻黄汤或桂枝汤合用，以治疗外感风寒所引起的咽喉疼痛。另外，本方还可改用散剂，将三味药等量研末，用温水或热米饮冲服，适用于慢性咽喉病变需长期调治者。

76.四逆散证

(1) 阳痿案一

李某，男，32岁。李某之妻探亲而来，一路辛劳，李某却欲当夜求欢，被其妻拒绝，因而七情受郁，竟成阳痿之证。曾多服温补壮阳之品，无济于事。诊其六脉皆弦，舌质红苔白，更有胸胁痞满，因而辨为肝气郁结而相火悖逆，疏泄之用废弛而阳气内郁不达。气有余必化火，则内伤其阴；又屡服壮阳之品，使阳气更壅而气机更阻。必当开郁理气，兼和其阴。

柴胡12克 枳实10克 白芍10克 炙甘草10克 生地10克 熟地10克 天冬10克 麦冬10克 丹皮10克 茯神10克

服药仅三剂，阳气通畅而愈。

(2) 阳痿案二

张某，男，20岁。病人自述阳痿已3年，伴有遗精、滑精，小便黄短不利，少腹闷而不舒。脉沉弦有力，舌红苔薄黄。此青年未婚而阳痿不起，病多始于有所思而不能遂愿，久之而成气郁，郁则阳气不达故阳痿；郁而化火，相火妄动，故遗精梦滑。治宜以开郁为先。

柴胡12克 枳实12克 白芍30克 炙甘草9克

服药四剂后，少腹觉舒，遗精已止。原方又服六剂，病人自述晨起时阴茎已能勃起。此气机已开，改用龙胆泻肝汤以清肝胆之火。服用六剂后，各方面均已正常，嘱其慎养为宜。

(3) 女子阴冷案

徐某，女，32岁。肝郁为病，胸胁胀满，善太息，呕吐酸苦，月经前后不定期，小腹疼痛。自患疾以来性欲冷淡，厌夫独宿，神情抑郁而默然。脉沉弦，舌苔白。大凡肝肾同源，其气相通，所以肝郁极易导致肾气亦郁。肾主二阴而司生殖，肾郁气结，则机能不用，故而春情泯灭，意志消沉。当用四逆散开郁舒肝，以开肾气之郁。

柴胡15克 枳实12克 白芍15克 炙甘草10克 郁金10克 菖蒲10克

服药共约七八剂而愈。

(4) 阳郁挟饮案

刘某，女，33岁。患脘腹胀满，连及两胁，以小腹为甚，并自觉腹

中寒栗而冷，大便初硬后溏，有时挟血，病程已一个多月。平素月经后期，量少色深，脉沉弦，舌苔薄白。先以四逆散合小柴胡汤治之，服药三剂后，小腹胀满明显减轻，但腹中内寒反而加剧，再审其舌，舌体胖而舌质淡，苔水滑，乃知非但阳气内郁，并且挟有水饮邪气。

柴胡10克 枳实10克 白芍10克 炙甘草10克 桂枝 10克 茯苓15克 大枣8枚

服药六剂后，诸症全部消失，大便转常，腹中转温。以四逆散加茯苓、泽泻以调其后。

（5）气郁厥证案

全某，男，32岁。患者手足厥冷，疼痛麻木，不堪其苦。厥冷时手足汗出，其汗出程度随厥冷之深浅而变，厥深则汗多，厥浅则汗少。曾服附子、干姜等回阳救逆而无效。视其人体格健壮，面颊丰腴，两目有神，决非虚人之象。诊其脉沉弦而有力，舌质红苔白。脉沉有力，主肝胆气机郁结。气郁阳结，疏泄不利，则阳气受阻不能达于四肢，所以四肢厥冷，然阳郁则热逼津液外渗故汗出。此非阳虚之寒厥，亦非阳盛之热厥，乃是“阴阴不相顺接”之气郁厥证。用四逆散疏达气血以通阳气，使阴阳气相互顺接则愈。

柴胡10克 枳实10克 白芍10克 炙甘草10克

服药一剂后，患者自觉有气自心下部位往下行走，直抵少腹，腹中微微而动，顿感周身轻爽，随之而手足转温，汗出减少。二剂后，四肢疼痛麻木有明显好转，但汗出仍不能止。上方中加桂枝6克，牡蛎30克，意在取桂枝配芍药以和营卫，牡蛎敛汗以和阴阳，又服二剂，则手足转温，汗已止其六七，患者自以为病愈而未来复诊。

过4天后，病证复发，厥汗如初。为何药已奏效而不能持久？思之良久而认识到，郁结之阳虽然已通，但被郁火所伤之阴未能及时滋补。阴不足而不能制阳，则反被阳逼而为汗；汗出更伤其阴，阳无偶则自郁而复厥。唐人王冰曾说：“益火之源以消阴翳，壮水之主以制阳光”。所以，郁阳之气宜疏，而弱阴又不可不救，乃用四逆散与六味地黄汤合用，重用熟地30克，又服六剂，厥回冷消，汗出已止。此后再未复发。

【解说】

四逆散是治疗少阴阳气郁遏，枢机不利而致四肢厥冷的主方。少阴主水火二气，内寓真阴真阳。心肾之水火阴阳相交既济，是人体正常生命活动的必要条件之一。而维护水火阴阳的交济，则有赖于少阴的枢机作用，所以说：“少阴为枢”。如果说少阳为三阳之枢，是调节周身气机内外上下运动的重要枢纽，那么，少阴为三阴之枢，则是调节水火阴阳

的重要枢纽。少阴枢机不利，阳气被郁，不能通达于四末，即可以导致四肢厥逆。四逆散中用柴胡、枳实解郁开结以疏达阳气；芍药配甘草利血脉以和阴气，即所谓“治其阳者，必调其阴；理其气者，必调其血”。根据临床观察，导致少阴气郁致厥的原因主要是在外感热病过程中，过早地或过量地使用寒凉药物，阳气冰伏，而闭郁于内。至于肝肾同体而由于气郁阳结的则多属情志所伤，亦不能排除在治疗之外。

少阳为枢，少阴亦为枢，其枢机所主虽然各不相同，但其枢机以利阴阳之气升降出入则一；所以小柴胡汤与四逆散皆用柴胡解郁利枢为主，然少阳气郁，每每引起相火郁悖，所以小柴胡汤有黄芩以清之；少阴气郁，往往导致气血阴阳不利，所以四逆散中有芍药以和之。以上将两方之异同大概进行了分析，以备方之参考。

77.吴茱萸汤证

(1) 胃脘疼痛案一

刘某，男，32岁。有十二指肠溃疡病史，现今右上腹疼痛，每于夜间发作，伴寒战，呕吐酸水，大便反干，舌苔水滑，脉沉弦而缓。

吴茱萸12克 生姜15克 党参9克 大枣12枚 当归15克

服药一剂，疼痛缓而吐酸减，又加香附、高良姜各6克，三剂后疼痛止。

(2) 胃脘疼痛案二

某女，32岁。主诉胃脘疼痛，多吐涎水而心烦。舌质淡嫩，苔水滑，脉弦无力。初以为胃中有寒而心阳不足，投以桂枝甘草汤加木香、砂仁，无效。再询其证，有烦躁夜甚，涌吐清涎绵绵不绝，且头额作痛，辨为肝胃虚寒挟饮。

吴茱萸9克 生姜15克 党参12克 大枣12枚服三剂后诸症皆消。

(3) 呕吐案

周某，男，27岁。患慢性肾炎而住院治疗，症见：恶心呕吐，泛逆酸水，至夜间则发生寒战，全身振栗如疟，其人面色黧黑，舌质淡嫩，苔薄白而润，脉弦缓无力。

吴茱萸12克 生姜15克 党参9克 大枣12枚

共服药五剂，呕吐与寒战皆止。唯肾炎化验仍有蛋白。

(4) 呃逆案

姜某，女，39岁。患呃逆，连声不断，声低无力，而且心下逆满，时时气窜作痛，纳呆，神疲乏力，面色萎黄。舌苔白润，脉弦无力。此属胃气虚弱，中焦运化无权，肝气挟寒饮冲逆所致。

吴茱萸9克 生姜15克 党参15克 大枣12枚 茯苓9克 桂枝9克 炙甘草9克 陈皮15克

服药二剂，小便甚利，胃中觉宽，呃逆止而饮食增进。

(5) 脘胁胀满案

丁某，男，53岁。胃脘及胸胁胀满，进食后更甚，以致饮食日减，四肢乏力。舌质淡苔白而滑，脉弦缓无力。此乃厥阴肝经之水寒上犯胸

阳，气闭为胀，必口中多涎。

吴茱萸12克 生姜15克 党参9克 大枣7枚 桂枝6克 厚朴12克

服一剂则胀满减，胸胁顿觉舒畅。上方内增加吴茱萸至15克，加半夏、茯苓涤饮和中，共服八剂而愈。

（6）腹包游移案

杨某，女，42岁。所诉之证甚奇，每日天将拂晓时，小腹部隆起一软包如鸡蛋大小，从下往上游移，抵胃脘则呕吐苦水黄涎，伴头目眩晕。每次发作约2小时左右，然后自动消失，舌苔白而水滑，脉沉弦。此属厥阴寒气挟饮而上冲于胃，以致胃寒气逆。治当暖肝温胃，平冲降逆。

吴茱萸9克 生姜15克 党参6克 大枣7枚 桂枝9克 茯苓12克 白术6克 炙甘草6克 川椒炭6克 半夏9克 川楝9克 黄连2克

共服六剂而愈。

（7）腹痛案

闫某，男，37岁。有十二指肠溃疡病史，每夜子时，先左下腹发胀疼痛，继而呕吐酸水，伴寒战，头目眩晕。夜复一夜，很有规律。舌质淡嫩，苔白润，脉弦缓无力。

吴茱萸12克 生姜12克 党参9克 大枣12枚 当归12克

服一剂即效，连服十六剂而愈。

（8）头痛案

陈某，男，49岁。症见：头痛以巅顶为甚，伴眩晕，口中多涎，寐差，面色黧黑，舌苔水滑，脉弦迟无力。此厥阴水寒循经上犯清阳所致。

吴茱萸15克 生姜15克 党参9克 大枣12枚

服药二剂，头痛止而寐仍不佳，改用归脾汤三剂而安。

【解说】

吴茱萸汤证在《伤寒论》中共有三处，一是“食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之”；二是“少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之”；三是“干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之”。《金匱要略》中尚有“呕而胸满者，茱萸汤主之”之文。涉及阳明、少阴、厥阴三经病变，但从其方证分析，以肝胃虚寒而气逆为其病机特点。吴茱萸气辛而味苦，气味俱厚而能降，为厥阴寒邪上逆之专药，治呕吐头痛最佳；佐以生姜之辛散，温胃而散饮；合参、枣甘温补中，益气以扶虚。

全方具有温暖肝胃，散饮降逆之特点。

从所治各个案例来看，在辨证上均有反映其病机特点的共性，即呕恶，吐酸水或多涎，舌淡嫩，苔白润或水滑；脉弦或缓或迟而无力。临床上治疗呕吐，胃痛，头痛，呃逆，胁腹胀满等病症，凡具备上述辨证共性者，用吴茱萸汤为主治，每获良效。

在临证时还有一个不可忽视的特点是：本证往往在夜半子时发作为甚，且伴有寒战。这是因为夜半阴气盛极，寒邪得阴气之助而肆虐；同时，阳气生于夜半，阳气生则与阴寒交争，所以证候加剧而有寒战。对此仲景书中虽然没有明言，但实际上已有所指，《伤寒论》说：“厥阴病欲解时，从丑至卯上”。说明了厥阴气旺之时，必然能与邪气抗争。

吴茱萸为三类有毒药物，一般用量在3~6克，但用在本方中剂量宜大，可用至9~15克。一方面剂量不大不足以温降厥阴寒邪，另一方面生姜、大枣又能监制并缓解其毒性。

吴茱萸汤有多种加味方法，加当归是最常用的一种。当归性温而润，为肝经血分之药，加入本方中寓有气血兼治，温寒而不耗血之妙。其他如胃脘痛甚者加良姜、香附；胁腹胀甚者加厚朴、半夏；气窜气逆合苓桂枣甘汤；头目眩晕，心下逆满者合苓桂术甘汤等。所加诸法，亦均与本方证的病机特点相符而又互相关联。

78.白头翁汤证

(1) 湿热利案一

姜某，男，17岁。入夏以来腹痛下利，每日六七次，下利虽急但排泄不爽，用力努责，仅有少许脓血黏液。伴见口渴思饮。六脉弦滑而数，舌苔厚腻。此属厥阴湿热下利，即唐容川所说“金木相沴，湿热相煎”之证。

白头翁12克 黄连9克 黄柏9克 秦皮9枚 滑石18克 白芍12克 枳实6克 桔梗6克

服二剂后，大便次数减少，后重下坠已除。又服二剂，脓血黏液止。但腹中有时作痛，转用芍药汤二剂而愈。

(2) 湿热利案二

某妇，自诉：下利腹痛，脐腹部有冷气感。初辨为下焦有寒，气血不和，用桂枝加芍药汤治之，服药后腹痛反剧，以致疼痛不可忍耐，里急后重，小便短少黄赤，舌红苔腻，脉弦数。乃知此为厥阴湿热下利，湿热内蕴，热被湿裹，气郁不伸，所以脐腹部位有冷气感。

先令服六一散10克，再服白头翁汤，一剂即愈。

【解说】

白头翁汤为治疗厥阴病热利口渴下重而设。厥阴热利，病位在肝。由于厥阴邪气从阳化热，加以肝失疏泄，而致气滞湿聚，热与湿合，则成湿热互蕴之变。湿热下迫肠中，津被热伤，血被热腐，则下利脓血而口渴欲饮；气机被壅而不畅，则里急后重而反难通。所以，白头翁汤证的辨证要点是下利后重，便脓血，口渴欲饮。本方既能清热燥湿，又能凉血舒肝，临床上用以治疗菌痢、毒痢，或阿米巴痢疾，只要辨证属于厥阴湿热下利，无论病程长短，都能取得效果。

79.白头翁加阿胶汤证

久利伤阴案

胡某，女，73岁。患下利赤白，腹痛后重已半年多。大便每日三四次，有红白黏液，伴口干口渴，两目干涩。脉弦，舌质红而少苔。

白头翁10克 黄连10克 黄柏10克 秦皮10克 阿胶15克 白芍15克

前后共服九剂而安。

【解说】

白头翁加阿胶汤，原为“产后下利极虚”而设。因为产后失血伤阴，治疗时可加阿胶养血滋阴之药。同样，湿热下利日久而伤阴血，也需要加阿胶以调之。如本案已见两目干涩，舌红少苔等阴伤表现，但湿热病变仍在，所以用白头翁加阿胶汤既清湿热以止痢，又补阴血以益虚。

80.当归四逆汤证

(1) 腰痛案

郭某，男，28岁。患腰臀疼痛酸麻，入夜尤甚，疼痛难以转侧，诊其脉浮弦而细，证属血虚寒凝。

当归12克 桂枝9克 白芍9克 细辛6克 通草6克 大枣15枚

服三剂后痛麻俱减。上方加入桃仁、红花、炒穿山甲各3克，又服三剂而愈。

(2) 腹痛案

某男，患少腹疼痛，喜热畏寒。舌质淡嫩，脉弦而细，此为厥阴内寒证。

当归15克 桂枝10克 白芍10克 细辛6克 通草6克 炙甘草6克 大枣15枚 生姜12克 吴茱萸10克

服药二剂而痛止。

(3) 腰腹冷痛案

白某，女，32岁。深秋季节，在田间劳动时，适值月经来潮，因在野外就厕，当时自觉寒风吹袭下体，冷冽非常。不久即出现少腹冷痛，腰痛如折，难以忍耐。舌苔白润，脉弦细。此属经期风寒入客厥阴，络脉瘀滞而为病。

当归12克 桂枝12克 赤芍9克 细辛6克 通草6克 大枣7枚 鸡血藤12克 石楠藤12克

服药仅二剂而痛止。

【解说】

当归四逆汤是治疗厥阴血虚寒证的主方。厥阴属肝，肝体阴而用阳，主藏血液，所以肝虚多以血虚为主。血虚则失其温煦之能，因而生寒，用当归四逆汤养血散寒以治之。若其人内有久寒，或沉寒冷积，或中焦寒饮，则在方中加吴茱萸、生姜以温散沉寒。

本方在临床上可用来治疗妇女经期受寒的痛经；寒疝腹痛；寒痹关节疼痛；较严重的冻疮疼痛；血栓闭塞性脉管炎及雷诺综合征而见有肢端厥冷、麻木疼痛，以及头目牵引疼痛等。凡属血虚有寒，或厥或痛，皆可选用，常能获得满意的疗效。

81.干姜黄芩黄连人参汤证

(1) 呕吐案

王某，男，29岁。夏月炎热时贪食寒凉之物，以致吐泻交作，但以呕吐为主，伴见心烦，口苦等证。舌苔黄而润，脉滑数。

黄连6克 黄芩6克 人参6克 干姜3克

另捣生姜汁一盅，兑入药汤中服。

只服一剂，则吐止而安。

(2) 腹泻案

杜某，男，1周岁。患儿自生下后即大便溏泄，每日数次，吮乳不佳，而且多吐，伴见口舌糜烂等证，久治不效。舌尖红，苔白，脉缓。

党参4.5克 干姜3克 黄连3克 黄芩3克 白术4.5克 竹叶3克 炙甘草4.5克

服药三剂，腹泻与舌糜俱愈。

【解说】

干姜黄芩黄连人参汤，具辛开苦降甘调之法，能调上下之阴阳以解寒热格拒之势。《伤寒论》中用来治疗上热下寒，寒热格拒所导致的“食入口即吐”。这种呕吐俗称“火吐”，来势较猛，入口即吐，不能停留。但“火吐”又分两种，如果是单纯的火热邪气所致的呕吐，则用大黄甘草汤治疗。而干姜黄芩黄连人参汤所治的呕吐是在“下寒”的基础上产生的，形成这种病证的原因是误用苦寒的药物伤了阳气，或多食寒凉食品，导致脾阳虚弱。脾家虚寒，则脾气不升而成泻，热邪在胃，胃气不降则成吐，中州不和而不能升降阴阳，最终难免寒自下寒而热自上热，而成寒热格拒之势，下寒格热于上，所以发生呕吐，同时，也往往伴有腹痛下利等下寒证候。

82.芍药甘草汤证

（1）筋疝案

李某，男，25岁。右腿鼠溪沟处突出一肿包如鸡蛋大小，表面不红，用探针刺之无物，但疼痛屈腿不能伸，强行拉直其腿则疼痛号叫，夜间小腿肚子痉挛抽搐。行步走路时必须架扶拐杖，足跟不能着地。中医外科诊为“鼠溪脓肿”，但治疗效果不显。舌质红而少苔，脉弦细而数。此乃足厥阴肝经血虚不能荣筋，筋挛而成，名为“筋疝”。

白芍24克 炙甘草12克

服药一剂则疼痛减轻，二剂后肿包消失，四剂服完，足跟着地，弃杖而如常人。

（2）脚拘挛急案

贾某，男，53岁。左腿肚子经常性拘挛，疼痛不能伸直，严重时能向外聚起一肿包。同时，大脚趾向足心处抽搐，疼痛难忍。脉弦，舌质红而少苔。阴血不滋，筋脉绌急而使脚拘挛。

白芍24克 炙甘草12克

连服四剂而愈。

（3）目昏案

刘某，男，68岁。有高血压病史七、八年。患两足胫拘挛已一年多，同时头晕而两目视物模糊不清，舌红苔薄白，脉弦。辨为肝血虚少之病变。《素问·五脏生成》说：“人卧血归于肝，肝受血而能视，足受血而能步。”今肝血不足，筋脉失养，故足胫拘挛，目睛视物不明。

生白芍30克 炙甘草12克

服药三剂后，足胫拘挛明显缓解，又服六剂，拘挛消失，视物清晰，但仍头晕，转用平肝息风之法调治而愈。

（4）髋关节疼痛案一

周某，女，12岁。因与邻儿戏耍，右髋部被踢，从此局部疼痛不可近之。后又出现低热，37.8℃，经西医确诊为：化脓性髋关节炎，疼痛部位微肿，扪之灼手，且右腿蹠屈不能伸。脉弦细而数，舌质红。先用芍药甘草汤舒筋缓急。

白芍30克 炙甘草15克

服药仅二剂则疼痛减半，又服二剂后右腿已能伸直。所奇者，服药后小便挟有白浊物甚多，疼痛随之而轻。服药前局部穿刺有脓液，服药后再穿刺则无。因局部仍有红肿热感，遂改用仙方活命饮消肿解毒，祛瘀止痛，又服十余剂而愈。

（5）髌关节疼痛案二

杨某，男，33岁。开始时右腿髌部疼痛，行步困难；两个月后，左腿也出现疼痛，不能行步，下肢肌肉逐渐萎缩。经某医院诊断为“两侧股骨头缺血性坏死”。诊其脉弦而细，舌质红绛苔薄。

白芍24克 炙甘草12克

服药三剂即效，疼痛减轻。考虑到病程久而血脉瘀滞不利，因而又疏：当归、赤芍、花粉、甘草节、丹皮各10克，乳香、没药、川芎、浙贝、陈皮、山甲珠、皂角刺各6克，银花12克。服三剂后，再用赤小豆当归散与芍药甘草汤交替服用两个多月，则诸证皆消。经×光片复查，两侧股骨头血运通畅良好。

【解说】

芍药甘草汤在《伤寒论》中用来治疗“脚挛急”。本方药味精简不繁，却具有酸甘合化为阴之妙，有柔肝和脾，滋阴养血，缓解筋脉拘急之功，善于治疗血脉不利所致的拘急疼痛。《朱氏集验方》称之为“去杖汤”，主治脚弱无力，行步艰难。临床经验证明，本方对于因阴血虚少而引起的两足痉挛性疼痛或腓肠肌痉挛性疼痛不可伸直，而见脉弦舌红者，多有良效。并且，对于化脓性髌关节炎及股骨头缺血性坏死所引起的局部疼痛或肿痛，先服芍药甘草汤缓急止痛，然后再用仙方活命饮化瘀散结，疗效甚佳。如果腿胫挛急，证情像芍药甘草汤证而无效时，酌加羚羊角、钩藤服之即瘥。

83.甘草附子汤证

寒湿痹痛案

杨某，男，42岁，煤矿工人，终年在潮湿阴冷之处劳动，寒湿邪气袭人。患关节疼痛已3年，近期加剧。骨节烦疼，手不可近，伴有心悸气短，胸闷尤其以夜间为甚。舌体胖大而淡嫩，脉软弱无力。

附子15克 白术15克 桂枝10克 炙甘草6克 茯苓皮10克 苡米10克

服药三剂后疼痛明显减轻，心悸胸闷等症转佳。又服三剂，疼痛基本控制。最后改用丸药长期服用而获痊愈。

【解说】

本案的辨证关键是抓住两个方面的证候，一是周身骨节烦疼而不可近的寒湿证；另一方面是心悸气短，胸满等阳虚证。甘草附子汤由附子、白术、桂枝、炙甘草组成，具有温经散寒，祛风除湿之功。其中附子、白术温肾健脾，行于皮内以逐寒湿邪气；桂枝、甘草温补心阳以扶虚，所以特别适用于心、脾、肾阳气内虚，而寒湿邪气外痹关节；或卒然受寒湿邪气，外伤筋骨，日久而致内虚者，多能取效，所以用治风湿性心脏病则更为理想。

84.桂枝附子去桂加白术汤证

寒湿痹痛案

韩某，男，37岁。患关节疼痛已有数年，周身关节酸楚疼痛，尤其以两膝关节为甚，屈伸不利，行走困难。每逢天气阴雨疼痛加剧。舌质淡嫩而胖，脉弦迟，大便反而干燥难解。此属寒湿邪气外着内困，脾虚不能健运之证。

附子15克 白术15克 生姜10克 炙甘草6克 大枣12枚 六剂。

服药后，周身发痒，如虫行皮中状，两膝关节出汗而黏凉，大便由难转易。改用肾着汤，服三剂后下肢疼痛止。最后用丸药调理，逐渐平安。

【解说】

桂枝附子去桂加白术汤是桂枝附子汤的变方。桂枝附子汤即桂枝汤去芍药加附子，它与桂枝去芍药加附子汤不同的是，桂枝附子汤重用桂、附，意在温经散寒除湿，专治风寒湿三气困阻肌表，郁遏阳气的“身体疼烦，不能自转侧”证。如果湿邪内困脾气，脾不健运，津液不能还于胃中而反大便硬，则去桂枝而加白术以健脾运湿。因为桂枝走表，与附子合用能耗散津液，而白术与附子合用，则既能行皮内而逐水气，又能健脾气而行津液。这些细微的机理，正是仲景用药配方精妙之处。本案所治，形象地再现了仲景方药的无比正确性。服药后周身如虫行皮中状而痒，即《伤寒论》所谓的“其人身如痹”，这是正气得药力资助，与邪气相争，湿气欲出之象。服药完毕两膝汗黏冷，反映了寒湿邪气由皮内而出，邪退正复，其病向愈。

85.竹叶石膏汤证

(1) 乳痈术后高热案一

杨某，女，23岁。急性乳腺炎手术后，高热39℃，遍用各种抗生素无效，兼见口腔黏膜层布满真菌。伴有心烦，呕吐不能食，二便自调，精神尚佳。脉数而无力，舌面因涂龙胆紫无法辨认。术后耗气伤阴，虚热内扰阳明而胃气上逆。治当清热滋液，和胃扶虚。

生石膏30克 竹叶10克 麦冬20克 党参10克 半夏 10克 粳米一撮 炙甘草10克

前后共服八剂，热退身凉，呕止胃开而愈。

(2) 乳痈术后高热案二

张某，女，25岁。乳腺炎术后发热在38.5℃~39.5℃之间，经用抗生素无效，又用“安乃近”发汗以退热，屡退屡升，几经周折，患者疲惫不堪。更见呕吐不能饮食，心烦口干，头晕而肢颤，舌质红，苔薄黄。此乃气阴两伤，气逆呕吐，必须清热扶虚，气阴两顾，方为合拍。

生石膏30克 竹叶10克 麦冬24克 党参10克 半夏6克 粳米一撮 炙甘草10克

服药四剂，热退而安。过二周后，又出现往来寒热，口苦喜呕，心烦口渴，脉弦苔滑等证，此为外感邪气内并少阳，用小柴胡汤加生石膏、桔梗，一剂而愈。

又附：乳痈案

陈某，女，25岁。新产后十六天，高热38.3℃，不恶寒，右乳内上方红肿疼痛不敢触碰，伴口苦咽干而喜饮，纳呆，大便干结，四五天一次，小便黄赤短涩。舌质红，苔黄腻，脉弦数。辨为阳明、少阳郁热内结，急当清热开结而两解阳明少阳之邪。

生石膏20克 竹叶、麦冬各10克 炙甘草6克 粳米一撮 柴胡6克 黄芩 银花 连翘 丹皮 白芍 花粉 知母 夏枯草各10克 生牡蛎15克

患者持方而归，未及时取药，当日下午体温骤升至39.5℃，并出现神昏谵语。其母又求治于西医，被告知西药影响母乳而不利于婴儿。在没办法的情况下，只好购取中药煎服。没想到服一剂后，当夜则汗出而热退。三剂服尽，右乳红肿疼痛大减，大便通畅，纳食增进，患者大

喜，复诊时告知乳汁不够流畅，口干欲饮，舌质淡，脉弦无力，仍用竹叶石膏汤益气养阴为主，兼用银花、连翘、白芷、青皮、夏枯草、当归等清热散结，进退十余剂而愈。

（3）产后眩晕案

刘某，女，28岁。产后患眩晕证，发则气逆呕吐。经多方治疗，效果不显，病程已二月。血压110~160mmHg，伴口干喉痒，心烦，夜卧不宁，纳差，二便尚可。舌质红少苔，脉弦细数。

生石膏30克 竹叶12克 麦冬35克 半夏10克 太子参 12克 粳米一撮 炙甘草6克 石决明30克 白芍20克 六剂。

服药后眩晕大减，呕止食增，精神转佳。上方去石决明加龙骨、牡蛎各15克，续服五剂而安。

【解说】

竹叶石膏汤由白虎加人参汤去知母，加麦冬、半夏、竹叶而成，因此可以看做是白虎加人参汤的一个变方。但是白虎加人参汤证在于阳明热邪为主，所以用知母配石膏以清热为主；而竹叶石膏汤证则重在气阴两虚为主，所以易知母为麦冬，加竹叶配石膏以益气养阴为治。妙在加半夏于大群辛凉药中，降逆止呕又能拮抗寒冷之药伤胃。因此，前者用于热邪甚而伤气阴，后者用于余热未尽而气阴已伤。

仲景用竹叶石膏汤治疗热病后期，气阴两虚，胃气上逆所致的虚羸少气，气逆欲吐，不欲饮食等，病机仍未离于阳明。所以，临床上用以治疗阳明经所主的乳腺病变，如急性化脓性乳腺炎，或自行溃破，或手术排脓后，症见：高热，心烦，神倦，不思饮食，恶心欲吐，舌红，脉数等，常能取得良好效果。

86.牡蛎泽泻散证

水肿案

赵某，男，55岁。患者周身肿胀，尤以腰以下为甚，小便短少不利，延绵半年，屡治不效。病初时，因咳嗽而后出现肿胀，目睑肿如卧蚕，面色黧黑而亮，腹胀大，下肢肿，按之凹陷成坑，大便干。舌苔黄白相杂而腻，脉弦滑。此证肺先受邪，治节无权而三焦不利，水道不得畅通，故而肿胀。若按“开鬼门”、“洁净腑”之法治疗，宣上以疏通水道则病当早愈。但前医犯“实实”之戒，反用温补脾肾之法，使邪气胶固。当今之计，仍须宣肺利气，行水消肿，使三焦得通，小便得利则可。

牡蛎12克 泽泻12克 花粉10克 海藻10克 杏仁10克 白蔻仁6克 苡米12克 厚朴10克 滑石12克 海金沙10克

服药一剂后，患者意欲大便，但所下不多，却突然遍身^热然汗出，顿觉周身轻松，如释重负。第二日，肿胀开始消减，服三剂药后，其病竟霍然而愈。

【解说】

《伤寒论》说：“大病差后，腰以下有水气者，牡蛎泽泻散主之”，说明了本方是专为腰以下水肿而设。但本方药力峻猛，若非邪气盛实者，应当慎用。张仲景在方后注说“小便利，止后服”，说明此方不宜久服。本案所治水气之邪较重，而有洁净腑之能，不料药后反而见汗出，这是因为始病在肺，治节不行，三焦不利，水道不通则为肿胀。牡蛎泽泻散疏通三焦以利水行，加杏仁、蔻仁、苡米利肺气，以行治节。药后肺气得利，下合于大肠则内窍开，故欲大便；三焦通畅，外合于皮毛腠理则外窍开，所以水气之邪得以从汗而解，气布津行，肿胀必消。

87.百合地黄汤证

百合病案

赵某，女，42岁。因患病而停止工作已半年多，症见：心中燥热而烦，手足心热，口苦而干但不欲饮。小腹发冷，或下肢觉凉，或晨起半身麻木，体乏肢软，月经量较多，大小便基本正常。先服温经汤，反增烦躁，夜寐不安。其人多言善语，精神呈亢奋状态，如有神灵所作。脉细数，舌苔中黄。

生地16克 百合12克

服药三剂后，效出意外，燥热得安，其余各症亦有所改善。又服三剂，燥热亢奋现象已得控制，夜能安寐，从而他症亦消，病人喜不自禁。最后用百合地黄汤加柴胡、黄芩各10克调理，而恢复了正常工作。

【解说】

百合地黄汤能养心血，滋肺阴，凉血清热，是治疗“百合病”的主方。结合百合病的病机为邪热在于心肺，心肺有热，则耗伤气血，气血内伤，不能奉养心神，则心不能为神明之主，所以见证皆如神明所作。百合地黄汤治百合病，用之则效。《医宗金鉴》曾经说过：“伤寒大病之后，余热未解，百脉未和，或平素多思不断，情志不遂，或偶触惊疑，卒临景遇，因而形神俱病，故有如是之现证也”。印之于临床实践，其说确为中肯。

88.防己黄芪汤证

浮肿案

李某，女，32岁。周身浮肿已一年多，两腿按之凹陷成坑。小便不利，食欲不振，神疲体乏，望其面色黄白虚浮。舌质淡而体胖，脉沉缓无力。初用五苓散加苍术、附子，服二剂后略有所效，改用防己黄芪汤治疗。

黄芪30克 防己10克 白术60克 生姜10克炙甘草 10克 泽泻15克 茯苓15克 肉桂6克 车前子18克 大枣7枚

用六大碗水，煎药成二大碗，分温4次服完。再煎时，用三大碗水，煎成二碗，分温3次服，二剂药后，小便畅利而肿消。

【解说】

在《金匮要略·水气病脉证并治》中，防己黄芪汤是用来治疗卫虚的风水证。“风水”的病机关键在于脾气内虚，不能运化水湿，水邪外渍皮内而为肿。本案由于肿势较严重，所以合用《石室秘录》中的“分水丹”法，使方药构成三补一泻之法，并且制大其剂，使其迅速奏效。

除了治疗风水证以外，防己黄芪汤的几种加减方法在临床上也很有讲究：如脾胃虚弱，血脉不和所致的腹痛，加芍药；水湿伤肺作喘加麻黄；水寒上冲加桂枝；以及下有陈寒积冷时加细辛等等，皆不可忽略。

89. 葶 苈 汤 证

（1）痰湿胸痛案一

某男，颈之两旁憋闷作疼，掣及前胸与两臂，疼痛或有剧时，脉沉弦，舌尖瘀斑。西医诊断为冠心病，中医辨证属心肺两脏气血瘀滞，痹而不通。

苡米30克 冬瓜仁30克 芦根30克 桃仁12克 浙贝15克 射干10克 郁金15克

服三剂后，疼痛减半。上方又加桔梗、枳壳各10克，丹参18克，再服三剂而痛止。

（2）痰湿胸痛案二

于某，男，46岁。患喘咳病，喘平而仍咳，胸痛胸满，恶心欲呕，饮食不香。六脉弦滑，舌苔厚腻。证属痰湿上闭，肺气不利。

苡米18克 冬瓜仁30克 芦根30克 桃仁12克 杏仁 10克 贝母10克 郁金10克 菖蒲10克 陈皮10克 佩兰10克 通草10克

三剂而安。

（3）湿热痰咳案

王某，男，37岁。患咳嗽，吐黄黏稠痰已三月，偶见胸痛。舌体胖大苔白，脉弦滑。证属湿热蕴结胸肺，日久阻络。

苡米30克 冬瓜仁30克 芦根30克 桃仁10克 杏仁10克 桔梗10克 马兜铃10克 枳壳6克 滑石12克 通草3克

服六剂咳止。

【解说】

葶苈汤为治疗肺痈“咳有微热，烦满，胸中甲错”而立。方中葶苈能清肺泄热，利肺滑痰，配冬瓜仁涤痰散结，配苡米能利湿排浊；桃仁活血祛瘀，通经络之闭阻，且能泻血分热毒。全方具有泄热散结，涤痰行瘀之功。临床经验证明，凡病在上焦心肺胸中，属于痰湿或湿热上痹，阻闭脉络，以胸中满闷疼痛为主证，服之有特效。一般重用芦根、冬瓜仁及苡米。如疼痛较重者，加郁金、射干、贝母理气开痹；或咳吐浊痰，泛恶欲吐者，加杏仁、枳壳、桔梗上宣肺气；加通草、滑石则下行湿浊。

90.旋覆花汤证

胁痛案

白某，男，27岁。左胁疼痛以夜间发作为主，伴见心下痞，暖气，患疾已两年，自称每每以手自击其胁可使疼痛减缓。舌质绛而苔白，脉弦缓。此证名为“肝着”，非旋覆花汤不能治。

旋覆花10克 红花6克 桃仁6克 青葱管10克 紫降香6克 片姜黄10克 当归尾10克 柏子仁10克

服药三剂，胁痛若失。因其大便不爽，上方加糖瓜蒌30克。

【解说】

旋覆花汤由旋覆花、葱白、新绛三物组成，功能舒肝利肺，下气散结，活血化瘀，主治肝失疏泄，气血郁滞而留着于肝络所致的“肝着”证。“肝着”的证候特点是胸胁痞闷或胀痛不休，而其临床辨证的着眼处则是“其人常欲蹈其胸上”，本案即是抓住这一特点加以施治。新绛药店不售，因此常以红花、茜草等代替。本案加降香行气以助旋覆花之力；加红花、桃仁、当归尾、片姜黄活血化瘀以代新绛之用；加柏子仁养血柔肝以缓肝之急。合而观之，似比旋覆花汤为重。

91.甘姜苓术汤证

(1) 肾着病案

刘氏之妻，37岁。患腰部酸楚疼痛，白带淋漓，味臭难闻。脉沉缓无力，尺部脉更弱，舌体胖大而嫩。其人形体虽肥但气怯乏力。此乃寒湿下困肾阳，即《金匱要略》所谓的“肾着”病。

干姜12克 茯苓18克 白术12克 炙甘草6克 杜仲10克 续断10克

三剂而愈。

(2) 带下案

李某，女，23岁。患带下如崩，汨汨然不可止。病已半月，腰酸腿沉，体疲不堪，面色淡白无华。舌质淡，脉沉。此乃其人久处寒湿阴冷之地，以致脾虚不运，湿浊下注。

干姜10克 茯苓15克 白术30克 党参10克 黄芪10克 车前子10克 炒樗根白皮15克

共服五剂，带止而安。

(3) 腰腿疼痛案

刘某，女，26岁。患右侧腰臀及大腿酸重疼痛，而且带下极多。脉沉迟，舌质淡嫩而苔白。此寒湿下注腰肾，脾阳不能温焙之证。

干姜12克 茯苓16克 白术12克 炙甘草6克 杜仲10克 续断10克

四剂后，腰腿疼痛止，带下减七八。后以肾气丸巩固。

【解说】

甘姜苓术汤是治疗“肾着”病的主方，所以又称肾着汤。《金匱要略》对肾着病的特点描述为：“身体重，腰中冷，如坐水中”，注家皆以为腰腹寒冷如坐溶溶水泉之中。但根据临床观察和治疗经验，“如坐水中”一句注家认为应另有所指。即女子则见带下多，在男子则见阴部潮湿，不论带下或阴部潮湿，皆为水类，因其处在下身，而又特别多，非一般所能比，所以仲景以肖妙之语形容为“如坐水中”，这对于临床治病很有指导意义。临床所见肾着病以妇女为多见，但亦有见于男子。曾治一男子腰膝酸软无力，阴囊潮湿如水渍，每日三换其内裤，因投以肾着汤而愈。

肾着病的病机是脾肾阳虚而寒湿下着于腰肾，其辨证关键要抓住二

点：一是“腰以下冷痛”，如腰膝酸软，冷痛无力等；二是“如坐水中”，即妇女之带下或男子之阴湿甚重。参合舌质淡嫩，苔白，脉沉迟等特点，往往准确无误。

92.酸枣仁汤证

失眠案

齐某，男，18岁。两年前在学校与同学争吵之后，精神受到刺激，从此哭笑无常，打骂不分亲疏，被诊为精神分裂症而住院治疗两个多月。近半年来，自觉头晕昏沉，心烦不得眠，独居室内而恶见他人。脉弦细，舌质淡红苔白。证属肝郁血虚，肝失条达而燥热内生。

酸枣仁30克 川芎12克 知母12克 茯苓15克炙甘草10克 珍珠母30克
夜交藤15克

服药七剂后，头晕减，夜寐安。上方去珍珠母、夜交藤，又进十二剂，基本恢复正常，主动要求返校读书。

【解说】

本案病证始于情志所伤，肝郁为患。肝有郁结，则气不调畅，气不行则郁而为火，火能耗血，所以日久肝血为其所伤。肝血不足，不能柔养肝体，则使肝气更郁。这就是所谓的肝郁能致血虚，血虚又能导致肝郁的病理过程。酸枣仁汤能养肝血，柔肝气，专门治疗肝郁血虚所致的神魂不安证，所以服用后效如桴鼓。

93.射干麻黄汤证

(1) 喘咳案一

王某，男，47岁。久患喘促，冬季寒冷时发作尤为严重。每晨起漱口时常呕吐痰涎盈碗，清稀如鸡子白，夜卧时则喉中漉漉作响，口干，两眼周围出现黑圈，舌质淡胖，苔白润，脉沉弦而滑。

射干10克 麻黄10克 紫苑10克 款冬花10克 半夏15克 生姜15克 干姜3克 五味子4.5克 细辛4.5克 炙甘草3克 大枣7枚

服一剂喘咳减轻，呕吐止。将方中干姜加至6克，又服二剂而安。

(2) 喘咳案二

周某，男，47岁。咳喘多年，至深秋及冬令之时始作。发作时咳吐白色泡沫痰，喉中气鸣作响，甚则不能平卧，面色黑，舌苔白滑，脉沉弦。

射干10克 麻黄10克 紫苑6克 款冬花6克 半夏12克 生姜12克 五味子3克 细辛6克 大枣7枚

服六剂，咳喘大减。改服小青龙汤三剂，药后周身微似汗出，气机调畅，诸症悉除。

【解说】

射干麻黄汤善治水寒上闭之喘咳，是治疗寒饮郁肺，咳而上气，喉中水鸡声的主方。本方与小青龙汤，皆为治疗寒饮咳喘而设，用药同有麻黄、细辛、五味子、半夏，从临床上观察，这两个方证都可见到咳逆倚息不得卧，咳唾清稀泡沫样痰，而有水斑，舌苔白润或水滑等，这为正确地掌握其不同的临床运用带来了一定的困难。那么，应如何区别这两个方证的不同之处呢？首先，从病机角度看，小青龙汤证是外寒内饮俱重，而射干麻黄汤则以内有寒饮为重；前者以水饮为主，故能随气机之升降而变动不居，后者以痰饮为主，故能郁闭肺气，阻塞气道。其次，从证候表现来看，小青龙汤证可有明显的风寒表证，如发热，恶寒，身疼痛等；而射干麻黄汤则以喉中水鸣声为特征性表现。最后，从方药组成上，前者加桂枝以助表，用干姜以化寒饮；后者用射干以开闭利气，加紫苑、款冬花以化痰利喉。尽管有如此种种不同，但在临床运用时还应互相取法，比如王氏案因寒饮内盛而加干姜；周氏案经治后喉中不响而改用小青龙汤。

94.大黄牡丹汤证

(1) 痛经案

肖某，女，20岁。右少腹疼痛，按之有块，每逢经期更甚。大便干，小便赤，脉滑数有力，舌苔黄白杂腻。

大黄9克 丹皮12克 桃仁9克 冬瓜仁30克 苡米9克 赤芍9克 枳实9克 服三剂，块消痛止。

(2) 肠痈案

徐某，男，44岁。先作痔疮手术，后又用药物灌肠，因而引发右少腹疼痛，痛势剧烈，上抵胁胃，摸之有一索状物。大便下利，每日五、六次，粪如烂肉挟有黏液，但泄而不爽，饮食日减，体疲乏力。舌质绛，苔黄，脉弦滑。

大黄12克 丹皮12克 桃仁12克 冬瓜仁30克 苡米30克 柴胡12克 青皮6克 陈皮6克 败酱草10克

三剂后，泻出秽物甚多，随之而疼痛大减。转用桂枝茯苓丸加柴胡、大黄等，前后二十余剂而安。

【解说】

大黄牡丹汤是治疗肠痈的一张名方，仲景谓“脓未成，可下之，当有血”，“脓已成，不可下也”。但本方具有泄热逐瘀，凉血消肿，推陈致新的作用，所以，无论有脓无脓，凡肠痈热毒实者，都可以用本方加减治疗。

95.泽泻汤证

(1) 眩晕案一

王某，女，18岁。头晕眩冒，神疲不振，伴见带下极多，舌体胖大，脉沉而弦。证属心下有支饮，阻遏阳气不升。

泽泻24克 白术10克

服三剂而安。

(2) 眩晕案二

魏某，男，60岁。头目眩晕，耳鸣，舌体胖大，脉弦。证属饮气为病。

泽泻24克 白术10克

五剂后，眩、鸣减去七八，转服苓桂术甘汤而收功。

(3) 眩晕案三

朱某，男，52岁。患眩晕，两目懒睁，双手颤抖，终日昏昏若处云雾之中。其人舌体硕大异常，苔白滑根部腻，脉弦大无力。

泽泻24克 白术10克

煎药成，温分3次服。初服无反应，再服后不久，周身似有汗出，眩晕顿觉减轻，自觉两目有神。三服尽，续得小汗，从此头目清爽，后以五苓散、苓桂术甘汤配合服用十余剂而愈。

(4) 眩晕案四

李某，男，45岁。患眩晕数年，大凡平肝潜阳，滋阴降火，疏风散寒，补脾升清，安神定志等方药遍服而无效。询知眩晕甚时胸闷呕恶，四肢略颤，舌苔水滑，脉沉弦而滑，此病属饮家，泽泻汤主之。

泽泻24克 白术10克

服二剂已颇见功效。因其恶心欲吐，而改用小半夏加茯苓汤化饮和中。又服二剂，眩晕基本已消，转服温胆汤善后。

(5) 头痛案

董某，女，32岁。

头痛而沉重，如戴铁盔，舌体肥大，脉沉缓。

泽泻18克 白术9克 天麻9克

服四剂，头痛止。

（6）胁痛案一

王某，男，35岁。患慢性肝炎数年，右胁经常性疼痛，伴有头晕目眩而下肢浮肿，舌体肥胖，脉弦大无力。此为肝失疏泄，脾湿内盛，清阳不升所致。

泽泻24克 白术12克 川楝10克 延胡10克三剂。

服药后小便畅利，肿消晕止，胁痛亦安。

（7）胁痛案二

常某，女，48岁。症见：胁痛，头晕而颜面浮肿，舌苔水滑，脉弦略沉。西医诊断为脂肪肝。

泽泻15克 白术15克 川楝10克 延胡10克

守方服十余剂，肿消晕止，胁痛明显减轻。

【解说】

泽泻汤见于《金匮要略·痰饮咳嗽病篇》，其治疗“心下有支饮，其人苦眩冒”。“支饮”证属四饮中的一种，临床表现比较复杂，治法也比较多。除泽泻汤证外，还有木防己汤治疗膈间支饮，厚朴大黄汤治疗“支饮胸满”，葶苈大枣泻肺汤治疗“支饮不得息”等等。单就泽泻汤而言，是治疗支饮上犯头目而出现眩晕，临床疗效的确很好，但是，《金匮要略》对本证的记述过于简单，临床上较难掌握。根据临床经验，特作如下补充：“苦眩冒”一证是指头目眩晕之苦，有莫能言状之意。它不同于普通的头目眩晕，而是终日昏昏若处云雾之中，或头沉如戴铁盔等。其次，望舌对诊断本证有特殊意义。一般来说，水饮之舌质必淡，舌苔水滑或白滑。但泽泻汤证的舌体往往是特别的肥大而异乎寻常，占满口腔使人望之骇然。泽泻汤临床治疗还不止眩晕一证，还可治疗饮邪上冒所致的头痛，头沉，耳鸣，鼻塞等。

清人林丰礼曾说：“心者阳中之阳，头者诸阳之会。人之有阳气，犹天之有日也，天以日而光明，犹人之阳气会于头，而目能明视也。夫心下有支饮，则饮邪上蒙于心，心阳被遏，不能上会于巅，故有头冒目眩之病……故主以泽泻汤。盖泽泻气味甘寒，生于水中，得水阴之气，而能制水；一茎直上，能从下而上，同气相求，领水饮之气从下走。然犹恐水气下而复上，故用白术之甘温，崇土制水者以堵之，犹治水者必筑堤防也。”这段话生动地反映了泽泻汤的病机与治疗意义。

既然水饮为病，为什么不用苓桂术甘汤温药以化饮？这是因为泽泻

汤药少力专，能单刀直入而使饮去。如果用苓桂术甘汤，则嫌其甘缓而恋湿，但服泽泻汤后，水饮之邪已减，则苓桂术甘汤甘温之祛，也不能全废。

96.半夏厚朴汤证

梅核气案

张某，女，41岁。自觉咽喉部位有异物梗阻难忍，欲吞不下，欲吐不出，堵塞憋闷，或伴胸满，时时暖气，诸症以午后为甚。左脉沉右脉弦滑。此属痰凝气郁，肺气不利之证。

半夏15克 厚朴15克 生姜10克 茯苓15克 紫苏10克 桂枝9克

服药五剂后，异物梗阻感减轻，因其舌质红绛而减去桂枝，加竹茹12克，竹叶6克，灯心草1克，又服五剂而愈。

【解说】

半夏厚朴汤主治妇女“咽中如有炙脔”，吐之不出，咽之不下，堵塞憋闷，难以忍受，又称为“梅核气”。本方解郁化痰，理气开结，确为治疗本病的良方。案中加用桂枝，有下气降逆散结的作用。据《神农本草经》记载，桂枝有三气之功，一、能补中益气；二、能降逆下气；三、能散结行气。具体地说，例如：桂枝甘草汤、炙甘草汤中桂枝能温补心气；桂枝汤、小建中汤中的桂枝能和脾胃以健中气；而桂枝加桂汤、苓桂术甘汤等方中桂枝又能降逆下气平冲；而桃核承气汤中桂枝则能散结行气以治蓄血。临床实践证明，用半夏厚朴汤治疗痰气交郁的梅核气，如不能取效时，加上桂枝每每能收到良好的效果。所以，本案中加桂枝，取其散结气，降逆气之功。

97.桂枝茯苓丸证

(1) 月经淋漓案

宋某，女，30岁。患月经淋漓不断，少腹胀痛不堪，妇科诊断为“功能性子宫出血”。脉沉滑，舌苔薄白。此瘀血积在胞宫，阻闭经脉，新血不得归经。

桂枝6克 茯苓12克 桃仁6克 红花6克 川芎6克 当归10克 赤芍10克 生地10克 三剂。

嘱告病家，服药后当下血块，血来反多，此乃瘀血去而新血方能归经之佳象。不几日，果然经血自止。

(2) 痛经案

思某，女，27岁。月经前后不定期，每逢月经来潮，腹痛如锥刺，腰痛如折，舌质紫黯。此气血失和，宜通而忌补。

桂枝10克 茯苓24克 桃仁12克 赤芍10克 丹皮10克

三剂而痛止。

【解说】

桂枝茯苓丸是仲景治疗妇女妊娠而有瘀积的方剂，具有活血化瘀，散结消癥的作用，所以治妊娠癥积，要用蜜制为丸，每服一丸。如改为汤剂，用来治疗妇女经血失调，内有瘀血阻络，而以少腹刺痛为主证者，临床每获良效。若将本方与当归芍药散交替服用，治疗妇女子宫肌瘤，坚持服用，也能获得比较满意的效果。

98.当归芍药散证

（1）腰痛案

刘某，女，29岁。腰痛如折，带下来多，头晕而气短，月经衍期量少。脉弦滑按之无力，舌苔白。此肝脾失调，气血不利，内伤冲任之证。

当归10克 白芍16克 川芎6克 泽泻10克 茯苓12克 白术20克

服药五剂后，腰痛减轻，仍守上方服用，共进十四剂而痛止，带下消失。

（2）浮肿案

高某，女，42岁。身肿面浮，带下多，左侧少腹疼痛，经期更甚。自觉阴道内灼热，体倦乏力，脉沉滑而大，舌苔白腻。此乃脾湿太盛而肝不疏泄，气血凝滞之证。

当归10克 白芍18克 川芎10克 茯苓12克 泽泻12克 白术12克 川楝6克 延胡6克

服二剂肿消、腹痛减，带下减少。上方加香附、郁金各6克，再服二剂，大便排出红色黏冻物不少，腹中顿觉宽松，又加桃仁6克，服三剂，适逢月经来潮而诸症不发作，从此告愈。

（3）不孕案

刘某，女，30岁。经期腹痛，白带多，结婚8年来未孕，舌苔黄。证属肝脾失和，湿阻冲任。

当归12克 白芍20克 川芎9克 白术30克 茯苓20克 泽泻12克 黄柏3克

服药十二剂后，腹痛止，带下减。上方去黄柏，续服十二剂。病人携药回家，半年后来信致谢，已怀身孕。

【解说】

当归芍药散是仲景治疗妇人病的一张名方。方中芍药、当归、川芎养血和血以调肝；茯苓、泽泻、白术利水渗湿以健脾，具有调和肝脾，和血利湿之功。妇女以气血为本，所以病变往往以气血失调为主。脾为气血生化之源，肝为藏血调气之脏，肝脾一旦失调，则气血为病，由此而生。或肝气不柔，横犯脾土而致脾湿不运；或脾湿内盛，壅遏木气而使肝失条达。肝脾失和，气血逆乱，则使妇人患经带之证。所以，大凡

妇人病变，或带下，或月经不调，或痛经，或不孕等，都可用此方为主进行治疗。血瘀加桃仁；气郁加郁金、香附；带下多则重用白术；腰腹疼痛严重则多用芍药；加柴胡疏肝已具逍遥散之规模，但不能加熟地，因其呆滞而破坏全方之妙用。

99.温经汤证

(1) 肝寒呕恶案

靳某，女，28岁。患干呕恶心，时吐苦水，以晨起为甚，病已3年，月经先期，伴腰腹疼痛发凉，白带多，舌苔滑。

吴茱萸7克 当归10克 白芍10克 桂枝10克 川芎6克 丹皮6克 生姜12克 半夏12克 阿胶10克 党参9克 麦冬15克 炙甘草9克

服六剂后，除带下略多外，余症悉消。转用温胆汤化痰湿以止带下，又服六剂而安。

(2) 月经淋漓案

卢某，女，40岁。月经淋漓不绝，偶停而又复来，血中多挟瘀块。少腹冷痛，腰腿酸楚，或发寒热，两颧潮红，手心热，唇口干燥。脉沉弦无力，舌苔白而略腻。证属寒凝血海，冲任阴阳失调，先以温经汤暖胞宫，散寒邪，和气血。

吴茱萸6克 川芎10克 当归10克 白芍10克 党参10克 桂枝10克 半夏10克 生姜10克 丹皮10克 阿胶10克 麦冬18克 炙甘草10克

服六剂后，经淋已止，少腹冷痛减轻，但带下仍多。此脾湿下注，谷精流失，改服当归芍药散调养肝脾，六剂而带下止。

【解说】

温经汤集温、润药物于一体，能阴阳兼顾，有两方面的治疗作用：一是温经散寒，属气煦为阳的一面；二是滋阴养血，属血濡为阴的一面。能使寒者温而燥者润，瘀者行而下者断，务使气血温和，冲任得养，肝胆得润为制方之宗旨。所以，本方治疗妇女冲任虚损，月经不调，或经多不断，或崩中下血，以及半产漏下，瘀血停留，少腹急痛，手掌烦热，唇口干燥，久不受孕等证，都有较好的疗效。根据临床经验，凡用温经汤必须重用麦冬以滋肺胃之津液，又能通心脉而养营血，同时，还能监制吴茱萸、桂枝等温燥而避免耗阴，可以减少服药后引起的头晕，咽干，心烦等副作用。

下篇 医论集

1.张仲景当归剂的证治特点

张仲景以当归命名的方剂见于《金匱要略》中，计有赤小豆当归散、当归生姜羊肉汤、当归芍药散、当归贝母苦参丸、当归散和内补当归建中汤；见于《伤寒论》中的只有当归四逆汤一方。以上七张方子，从不同的病机、证候角度论述了当归这味药的治疗理论，明确了与当归相配伍的各药关系与特点，为后世医家运用当归及当归剂治疗各种疾病开辟了先河。

（1）赤小豆当归散

【原文】

病者脉数，无热微烦，默默但欲卧，汗出。初得之三四日，目赤如鸠眼，七八日，目四眦黑；若能食者，脓已成也。赤小豆当归散主之。
《金匱要略·百合狐惑阴阳毒病》

赤小豆三升（浸令芽出，曝干） 当归三两

上二味，杵为散，浆水服方寸匕，日三服。

此方治疗下焦湿热伤及阴血，以致前阴或肛门腐蚀溃烂，张仲景称之为“狐病”。如果毒热腐血而成脓，除前后阴溃烂或肿痛外，并见汗出，心烦，默默但欲卧，脉数，目赤如鸠眼，至七八日两目四眦皆黑，说明溃脓已成。本方能清利湿热，解毒排脓，化瘀生新。用赤小豆生芽之义，是取其生气最锐而能助肝胆之气以逐瘀血而消脓肿；借当归辛温而润，排脓止痛，和血补血以尽其功。王好古曾说：“当归入手少阴以其心生血也，入足太阴以其脾裹血也，入足厥阴以其肝藏血也。”当归

味辛而有香气，不仅擅治各种血病，还能理气解纷。凡气血昏乱所致病变，服之即定，故名当归。乌梅丸、当归四逆汤皆见于《伤寒论·厥阴病篇》，两方皆有当归，一治蛔厥，一治血虚受寒，手足厥逆。所以皆用当归者，因当归味甘性润，且有芬芳醒脾理气之功，既能补肝血以缓肝急，又能和肝气而利疏泄，况且补血而不呆滞，理气而不耗散，实为肝经气血兼治之良药。

（2）当归生姜羊肉汤

【原文】

寒疝，腹中痛及胁痛里急者，当归生姜羊肉汤主之。《金匮要略·腹满寒疝宿食病》

当归三两 生姜五两 羊肉一斤

上三味，以水八升，煮取一升，温服七合，日三服。

【原文】

产后腹中**痙**痛，当归生姜羊肉汤主之。并主腹中寒疝，虚劳不足。《金匮要略·妇人产后病》

本方主治厥阴血虚寒疝，少腹疼痛，及胁痛里急；或兼见头晕目眩，面色**晄**白，脉涩细弦沉，舌质淡嫩苔白。以及妇女产后，经期失血过多而发生寒气腹痛与虚劳不足等病。若寒多者，倍用生姜；若痛甚而呕者，加陈皮二两，白术一两。

厥阴血虚受寒，有在经与在脏之分，在里与在外之别。当归四逆汤证为经脉受寒，属厥阴经表病变。当归生姜羊肉汤证为经、脏皆寒，厥阴肝血虚、寒气收引的病变。当归味厚，补血养肝为胜；生姜味辛而散寒，健胃有功；《内经》说：“精不足者，补之以味。”所以重用羊肉有情之品直补其血，自然优于草木之品，羊肉选用赤肉剔去白脂，切成小块，慢火久熬，汁稠味浓，不加调料。肝开窍于目，目得血而能视，血虚严重者，临床每见头目眩晕，视物不清等证，服药后顿觉头清眼亮，说明已经见效。

（3）当归芍药散

【原文】

妇人怀娠腹中**疝**痛，当归芍药散主之。《金匱要略·妇人妊娠病》
当归三两 芍药一斤 茯苓四两 白术四两 泽泻半斤 芎蒭半斤
上六味，杵为散。取方寸匕，酒和，日三服。

【原文】

妇人腹中诸疾痛，当归芍药散主之。《金匱要略·妇人杂病》

本方治疗肝血不和，血不养肝所引起腹中疼痛的病变。肝以血为体，血不养肝则肝气横逆，血脉为之绌急拘紧，少腹疼痛，月事失调；肝气犯脾，影响脾的运湿化津作用，以致带下淋漓，小便不利，足胫浮肿，腰腹沉重，头目眩晕等证。本方用当归补血柔肝，配芍药平肝解痉以缓拘急，芎蒭芳香而窜，为血中之气药，解郁疏肝以行血气；白术培土以胜湿，茯苓、泽泻淡渗以利湿，使脾土健运，以灌四旁，则少腹疼痛与经带之病必然迎刃而解。本方养血平肝，崇土运湿。深得妇科之要妙，对不孕证也往往有效。

如果虚热上扰而见心烦头晕或头疼者，加白薇；带下多而尿黄有臭味者，加滑石、苡米、椿皮、龙胆草等药；午后发热，经行不畅，色紫有块者，加丹皮、茜草等药。

（4）当归贝母苦参丸

【原文】

妊娠小便难，饮食如故，当归贝母苦参丸主之。《金匱要略·妇人妊娠病》

当归四两 贝母四两 苦参四两

上三味，末之，炼蜜丸如小豆大，饮服三丸，加至十丸。

此方治疗妇女妊娠血虚而又湿热相结，小便困难，或续发水肿（子

肿)。血虚则肝气不和，湿热相结于下则小便不利。此证如单用利水渗湿之法则更伤其阴，胎无血养则堕；如单纯补血滋阴则能更助湿邪而使道闭塞不通，水肿更甚。此证多见虚热之象，小便不利，尿色发黄，或大便秘结。用当归补血疏肝以养胎气，贝母开利肺气以行治节，苦参清利湿热则小便自通。服丸渐加，为妊娠立法，以示谨慎。

（5）当归散

【原文】

妇人妊娠，宜常服当归散主之。《金匮要略·妇人妊娠病》

当归一斤 黄芩一斤 芍药一斤 芎蒭一斤 白术半斤

上五味，杵为散，酒饮服方寸匕，日再服。

妊娠主要靠血液养胎，血室系于肝，统于脾，滋灌于冲任，所以用当归、芍药、芎蒭补养肝血为先；白术健脾资化水谷精微而摄固冲任之脉；大凡妊娠有身则易生内热，而耗血阴，所以用黄芩清热以坚阴。

（6）内补当归建中汤（载于《千金要方》）

当归四两 桂枝三两 芍药六两 生姜三两 甘草二两 大枣十二枚

上六味，以水一斗，煮取三升，分温三服，一日令尽。若大虚，加饴糖六两，汤成纳之，于火上暖令饴消。若去血过多，崩伤内衄不止，加地黄六两，阿胶二两，合八味，汤成纳阿胶。

根据记载，本方主治妇女产后虚羸不足，腹中刺痛不已，呼吸少气，或苦少腹中急，掣痛引腰背，不能饮食。产后失血，血不养肝则肝急，肝气急则横逆，而使脾气不和。脾主大腹，所以出现腹中急痛，以及虚羸不足之象。小建中汤本身即具有建中缓急，调和肝脾的作用，加当归又补其阴血，血足则肝柔，而脾健气运，诸证必然迎刃而解。

（7）当归四逆汤

【原文】

手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。《伤寒论·厥阴病》

当归三两 桂枝三两 芍药三两 细辛三两 甘草二两 通草二两 大枣二十五枚

上七味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

本方为厥阴经血虚受寒而设。用当归滋养血脉，细辛开痹气，通草行经络，多用大枣缓急生津以防止细辛耗液伤津，桂枝、芍药、甘草滋阴和阳，调和营卫。运用本方时一定要以脉细，舌质淡嫩，苔薄白为标准，临床有以下几点，务须记清：

- ①手足厥冷，脉细欲绝；
- ②周身疼痛，脉细而弦，用一般治痹方法无效时；
- ③两侧少腹疼痛，脉弦细而迟缓，则加生姜、吴茱萸；
- ④腰痛，脉细而小便反利，其疼痛特点是日轻夜重；
- ⑤头痛，脉细，口淡不和；
- ⑥疝气腹痛，少腹拘急，脉弦细，加生姜、吴茱萸、小茴香；
- ⑦冻疮，手脚肿痛不消，至冬季遇寒则发。

（8）小结

综观以上七方，可以得出这样一个结论。当归赤小豆散有祛瘀生新，排脓解毒，消肿止痛的作用，其中当归以祛瘀生新为主；当归芍药散能调经理痛止带，其中当归以补血养肝为主；当归四逆汤治厥阴血虚感受寒邪，当归以养血温寒为主；当归生姜羊肉汤治厥阴经脏皆寒，胁腹急痛，其中当归以温养肝血为主。至于当归散治妊娠胎不安，当归贝母苦参丸治妊娠小便难，内补当归建中汤治产后失血腹痛，其中的当归有调经，安胎，止痛，缓急与理气之功。由此看来，当归为补血、生新、祛瘀、养胎、调经之品，能使肝、心、脾三脏皆受血液的荣养，而促使血气从紊乱局面恢复正常。

2.心悸的辨证与治疗

心悸指的是心律搏动失常而发生的心跳、心慌的一种病症。悸，《说文》训为“内动”，心悸，也就是心内动。有的医书也叫“心筑惕”，筑，形容心悸犹如物捣之状；惕，则指悸动而心神不安。

心是一个有节律搏动的脏器，正常情况下，这种搏动在是不知不觉中进行着。“心悸”是一种失常的搏动，没有节律可言，它使人有明显的心跳、心慌的感觉，并往往伴有胸满、气短等症，属于病态的反应。从中医角度来讲，心悸主要分为心虚失养，与心被邪扰两大类。

（1）心虚失养的心悸

1) 心阳虚类

阳虚心悸：

《素问·六节藏象论》说：“心者，生之本，神之变也……为阳中之太阳，通于夏气。”这段话是说心为生命的根本，而主宰神明的变化。心有这种功能是其阳气的功能所决定的。心属火脏，而又上居于胸中；胸为阳位，火亦属阳，两阳相合，所以把心称作“阳中之太阳”。由于阳气主动，阴气主静，所以心脏能不息地搏动，从生到死，莫不以阳气为先决条件。由此可见，心主血脉与神志，也与阳气的主导作用有关。如果离开了阳气，心就停止搏动，血脉不流，神志消灭。因此，凡是由于各种原因，伤伐心的阳气，如治疗上的发汗过多；或过服苦寒药物而内伤阳气；或因年老阳虚，以及禀赋虚弱等等，都可以导致心阳虚的心悸证。

心阳虚的心悸特点，反映于外的则是患者用两手交叉按其心上，往往伴有体疲无力，少气懒言等证象。脉缓弱无力，有时也可出现间歇，舌质淡嫩，舌苔薄白。治疗应当甘温扶虚，以补心胸阳气，可用桂枝甘草汤治疗。

桂枝甘草汤方

桂枝12克 炙甘草6克

方中桂枝气味辛温，能上补心阳而温养血脉之寒；佐用炙甘草，复脉补虚，意在桂、甘相合，使其辛甘化阳，益气暖胸，温畅血脉，使心阳得养，则心悸自安。此方妙在药味单捷，要求一次服完，则药力专一，直达病所，发挥疗效。

医案一：

《印机草》载马元仪治一妇，病已一月，而脉浮虚，自汗恶风，此卫虚而阳弱也，与黄芪建中汤一剂，汗遂止……越一月，病者叉手自冒心间，脉之虚濡特甚，此汗出过多而心阳受伤也。仲景云：发汗过多，病人叉手自冒心，心下悸欲得按者，桂枝甘草汤主之。与一剂良已。

阳虚心悸烦躁：

如果在上述阳虚心悸的基础上，又兼见烦躁不安等，说明了阳虚而心神不能潜敛。治疗应该补心敛阳，镇静安神，用桂枝甘草龙骨牡蛎汤治疗。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤方

桂枝6克 炙甘草6克 龙骨12克 牡蛎12克

本方用桂枝、甘草补心阳之虚；龙骨、牡蛎潜敛神气而镇静安神。

阳虚心悸烦躁而手足厥冷：

若在阳虚心悸的基础上，又兼见烦躁而手足厥冷、脉沉而舌质淡者，反映了少阴心肾上下阳气皆虚。治疗应当心肾同温，上下兼顾，方剂选用茯苓四逆汤。

茯苓四逆汤方

茯苓12克 人参6克 炙甘草6克 附子12克 干姜6克

本方用茯苓、人参补益心气；干姜、附子、炙甘草温补心肾阳气，使心肾阳气得以内充，则心悸、烦躁、手足厥冷等证自然而解。如果症见手足发冷，胸满气短，尤其以入夜为甚，憋气情况非常危急，在上方中加入桂枝9克，生姜9克，大枣7枚，减去干姜，服用多有效验。

阳虚心悸而气冲胸咽：

上述阳虚心悸，也可兼见气从少腹上冲胸咽，颜面翕热如醉状，头目眩晕，这是由于阳虚于上，阴乘于下所致，其脉按之无力，舌质淡嫩苔水滑。治疗应当温补心阳，纳气归根，可用苓桂味甘汤治疗。

苓桂味甘汤方

茯苓12克 桂枝10克 五味子10克 炙甘草6克

本方桂枝配甘草能温补心阳；桂枝配茯苓则下气消阴；桂枝配五味子能潜阳于下，而敛气归根。

阳虚心悸作呃：

阳虚心悸，也可伴发呃逆，这种呃逆，属于心肾两虚，肾气不潜所致。呃逆发作时，有的气从下来，冲口作声而出；有的气呃至胸而还，不能冲口呃出；则使病人憋闷特别严重，痛苦莫可言喻。治疗应该心肾两温，纳气归根，可用都气汤治疗。

都气汤方

熟地30克 山萸肉10克 山药10克 丹皮6克 泽泻6克 茯苓6克 肉桂6克 五味子6克

本方用六味地黄汤滋补肾水；加肉桂能水中补火，以温阳气之虚；加五味子酸收，敛气归根，以收摄上冲之气。

医案二：

刘某，女，23岁。症见：心悸而脉结代，呃逆不时发作，如果气能呃出，则心胸为快，如果不能呃出，或及半而罢，则憋闷难忍。开始时投以苓桂剂，虽然有效但不巩固，所以改用都气汤，另加人参扶虚养气，定悸安心。服三剂则呃逆止，服六剂而心悸平，后用苓桂味甘汤巩固疗效。

2) 心阴虚类

阴虚心悸：

多因青灯愤读，劳神少寐；或用心不息，而阳用过极；或因情志之火内伤其阴，则心失阴血之养。阴不制阳，阳气浮动，血脉不调，心律不齐而发心悸。表现为心悸而烦，失眠少寐，口舌生疮，舌红少苔，脉细数。治应滋补心阴，凉血清热，可用补心汤为宜。

补心汤方

生地12克 玄参10克 丹参10克 天冬6克 麦冬10克 柏子仁10克 当归10克 酸枣仁10克 远志6克 茯神10克 党参10克 桔梗3克 朱砂粉1克（另包分冲） 五味子3克

本方用生地、玄参、天冬、麦冬滋养心阴；丹参凉血清心；柏子仁润心定志；茯神、远志安神养心；酸枣仁、五味子敛阴潜阳；当归补血；党参益气；朱砂镇心宁神；桔梗载药以达病所。

医案三：

李某，女，21岁。为考大学而温习功课，日夜相续，孜孜不倦。一日突然心悸发作，心烦意乱，夜不能寐，几天后又发现口舌赤烂，脉细数，舌光红无苔，月经先期而至。心阴虚而火动，先以黄连阿胶汤泻南补北；续用补心汤滋阴和阳，服十余剂而获效。

阴虚阳亢心悸：

如果阴虚心悸，续发厥阴心包风阳发动，症见心中憺憺大动，头目眩晕，行路不稳，耳鸣如蝉，肢颤手麻，心烦少寐，脉细而弦，或带结象，舌光红似锦而无苔。治疗应当滋阴补血，平息风阳。方用三甲复脉汤。

三甲复脉汤方

龟板15克 牡蛎15克 鳖甲15克 麦冬30克 生地30克 阿胶 10克 白芍10克 麻子仁10克 炙甘草12克

本方集大队滋阴之药与血肉有情之品，具有很强的滋阴息风功效。其中阿胶味甘，龟板、鳖甲、牡蛎味咸，能直走心、肝、肾三经而峻补其阴，阴滋则阳潜，配以麦冬、生地、白芍、麻仁滋阴润燥协助其功而万无一失。甘草扶心脾化赤而为血，复脉生营息风定悸。

3) 心之气血阴阳两虚类

心脾气血两虚而心悸：

此证由于思虑过度，或亡血失血之后，心脾气血两伤，不能奉养心主，而发为心悸。往往伴有周身无力，饮食不馨，精神恍惚，或健忘等证，面色^㿠白不泽，脉濡软无力。治疗应当温补心脾，气血两顾，可用归脾汤治疗。

归脾汤方

白术10克 人参10克 黄芪10克 炙甘草10克 当归10克 茯神10克 远志10克 炒枣仁12克 龙眼肉12克 木香3克 生姜3片 大枣3枚

本方用白术、人参、黄芪、炙甘草以补心脾之气；当归、龙眼肉则补心脾之血；茯神、远志宁心安神；枣仁补肝安魂；木香既能使诸药补

而不滞，又以味香通脾奉心，以发挥“归脾”的优势。

医案四：

许某，女，32岁。因其父去世而悲恸，又为家庭生活而忧虑，心绪万千，从而患心悸。终日痴坐，两目直视，夜不成寐，饮食俱废，延迟一个多月，形销骨立，卧床不起。脉弦出于寸口，舌苔薄白而默默少言。辨为肝气抑郁而脾气不和，用逍遥散原方加香附、郁金，服药后神情转佳，饮食有增，但仍夜不成寐，心悸不安。于是改用归脾汤加白芍、蒺藜，服至十余剂，心悸不发，夜能安睡，逐渐康复。

心之阴阳两虚而心悸：

心的阴阳两虚证，往往伴发于各种心脏病中；亦可发于虚人受邪，内震心宫。脉来结代，心脏动悸不安，或见少气，心神慌乱，不能自主等象。治疗应当益气养血，阴阳双补。方用炙甘草汤。

炙甘草汤方

炙甘草15克 人参10克 麦冬30克 生地30克 桂枝10克 生姜10克 大枣15枚 阿胶10克 麻子仁10克

用清酒与水各半，浓煎后分三次服用，令一日尽。

本方用炙甘草、桂枝温补心阳；麦冬、生地滋养心阴；人参补心气以复脉；阿胶育心阴而滋血；麻仁润燥以和胃肠；姜、枣调中而和营卫。本方补心阴之功大于补心阳。

医案五：

曾治一张姓农民，患风湿性心脏病已有数年，最近出现心慌，心跳，悸动不安，脉结代，舌苔薄白。辨为阴阳两虚证，援用炙甘草汤原方。因病人路途遥远，所以持方而归，连服百余剂，值春节前，来京叩见，告知心慌心悸得愈，同时“风心病”也大有改善。

（2）心被邪扰作悸

心被邪扰作悸，大致可分为四种情况：

1) 因惊作悸

《素问·灵兰秘典论》说：“心者，君主之官也，神明出焉。”根据

王冰的注释：“任治于物故为君主之官，清静栖灵故曰神明出焉。”如果一旦受到惊吓，神气浮乱，则心主不能自持，因而产生心悸。此证的特点是心悸不安，胆小善畏，入睡则噩梦连绵，惊叫而醒，身出虚汗，六脉弦而小数，或见动脉，舌苔薄白而润。治疗应当安神定悸，补心养正。方用朱砂安神汤。

朱砂安神汤方：

人参9克 龙齿12克 珍珠母30克 茯神10克 远志6克 炙甘草6克 当归10克 另研朱砂粉1克分冲

本方用人参、当归补正安魂；龙齿、珍珠母潜敛心神；茯神、远志宁心安神；炙甘草补心脾而和血脉；朱砂镇惊定悸而使神清梦稳。

医案六：

学生陈某，11岁，读书不用功，贪玩耍而又淘气。一日触动父怒，苛责之余，又加打骂，因而受到惊吓而发病。心慌神乱，每次入睡后不久便从梦中惊叫而醒，见人则两手抱持不放，两眼发直。其脉弦，印堂部位呈现青色，肌肉不时颤抖。用小剂朱砂安神汤，同时吞服牛黄镇惊丸而愈。

2) 痰热扰心而作悸

此证多因气郁不达，日久化热生痰，痰热相结，既犯胆腑又扰心神，发为心悸。往往伴有口苦，恶心呕吐，胆小善畏，或兼见“三幻”（即幻视、幻听、幻觉）症状，脉弦而舌苔白腻。治疗应清热化痰，定惊宁悸，方用温胆汤。

温胆汤方

半夏12克 茯苓12克 竹茹12克 生姜12克 枳实9克 陈皮9克 炙甘草6克

本方用半夏、竹茹清化痰热；陈皮、枳实利气行津以散痞结；茯苓健脾利水以消生痰之源；生姜健胃降逆以止呕，又能散水饮之结；炙甘草扶正而和诸药。

3) 膈饮犯心而作悸

此证因膈间停饮，饮为阴邪，必来搏阳，所以心悸不安，心下痞满，呕吐，头目眩晕。脉弦，舌苔水滑。治疗应渗饮于下，涤痰于中。方用小半夏加茯苓汤。

小半夏加茯苓汤方

半夏15克 生姜20克 茯苓30克

本方用小半夏汤温化痰饮而治呕吐；茯苓淡渗利水，以消膈间饮邪从小便而去。

医案七：

王某，男，26岁。心悸，头目眩晕，重则呕吐，曾服中药不效。因其舌苔水滑，脉弦直，辨为膈间支饮，用小半夏加茯苓汤，小便畅通，其证随之而消。

4) 水气凌心而作悸

水气凌心之心悸是属于水饮邪气，上犯心阳的一种病变。其特点是气从心下上冲心胸，从而心悸胸满，短气作咳，头目眩晕。脉沉弦，舌苔水滑。治疗应当温养阳气，降逆平冲。方用苓桂术甘汤。

苓桂术甘汤方

茯苓15克 桂枝10克 白术6克 炙甘草6克

本方桂枝配甘草温补心阳；桂枝配茯苓利水消阴，通阳下气；茯苓配白术，则行水消饮；茯苓配炙甘草，能扶虚宁心；炙甘草配白术可以崇土制水，扶正去邪。用药只有四味，但其中变化奥妙，相须相使，颇有千军万马之势。

3.人体的“津液链”

津液，是人体生命活动中的一种比较重要的物质，在一般意义上说，它包括了血液、精液、髓液、汗液、唾液……其含义比较广泛。津液的各种成分相互连接而能相互转化，就好像一条链子联在一起，所以把这种情况称为“津液链”。

津液主要是从饮食物化生而来的。《灵枢·邪客》说：“五谷入于胃也，其糟粕、津液、宗气分为三遂。”可见由饮食而变成的津液是带有某种原始物质的涵义。但严格地讲，津与液还有分别，《灵枢·决气》说：“何谓津？……腠理发泄，汗出溱溱是为津。何为液？……谷入气满，淖泽注入骨，骨属屈伸，泄泽补益脑髓，皮肤润泽是谓液。”古人认为津液之中体轻者可以外走腠理而为汗；体浊者可以内渗入骨而为髓。所以，津在外而属阳，液在内而属阴，可用来区别它们不同的属性和功用。

但总的来说，津液属于阴类，不能离开阳气的蒸化作用。具体而言，它必须借助脾气的运化，肾气的主宰，肺气的敷布和三焦相火的温煦及流通。《医医病书》中说：“窃谓津液虽属阴类，而犹未离乎阳气者也，何以言之？《内经》云：‘三焦出气，以温肌肉，充皮肤为其津，其流而不行者为液。’岂非液则流而不行，津则随气而行者乎？……验之于口气呵水，愈足征气津不相离矣。”它说明了阳能化阴，气能化津，以体现气津并行，相得益彰的机理。如果人体的阳气不能化气以行津，则三焦失去温煦和流通；肺气失去敷布，脾气失去运输，肾气失去气化，则津液可聚而为饮，或泛而为水，便可形成不同程度的痰饮与水气等病证。

津液是从饮食物生化出来的一种物质，至于它的形成与具体状态，在《医医病书》中已有比较详尽的说明。它说：“凡人饮食盖有三化：一曰火化，烹煮熟烂；二曰口化，细嚼缓咽；三曰胃化，蒸变传化。二化得力（指火化与口化），不劳于胃……胃化及毕，乃传于脾，传脾之物，悉成乳糜。”它具体分析了饮食消化所具备的各种条件和进行中的各种程序，并且确切地指出由胃传脾的津液，是呈乳糜状，其色白而质稠。它补充了《内经》的不足，是津液学说的一个新发展。正是由于“乳糜”状津液这个原始物质，才能进一步变生血液、精液和髓液，从而形成一条“津液链”联系在一起，以反映它们的衍生和变化。

血液是人体赖以生存的重要物质。《素问·五脏生成》说：“肝受血而能视，足受血而能步。”可见人体的组织器官是离不开血液的滋养。但是，血由津液所变生，是系于“津液链”中的一个环节。津液变生血液，见于《灵枢·痈疽》，它说：“肠胃受谷，津液和调，变化而赤为血。”《灵枢·营卫生会》亦说：“中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化精微，上注肺脉，乃化而为血。”清朝人尤怡在所著的《金匱翼》中也说：“盖三焦者，水谷之道路，气血之所终始也。若三焦调运，气脉平均，则能宣通水液，行入于经，化而为血，灌溉周身。”由此可见，血液是从津液中的精微分子化生而成。因此，可以肯定地说，津液为血液之母，明确这一观点，就为临床滋液以生血的治法奠定了理论基础。

津液不但能生血，而且又能化精生髓。众所周知，精有先天和后天之分。先天之精来自父母，是与生俱来的一种物质。后天之精，是指离开母体以后，借助饮食的营养而从“乳糜”的液体中不断补充与化合而成。《灵枢·五癯津液别》说：“五谷之津液，和合而为膏者，内渗于骨空，补益脑髓。”其中“合而为膏”的“膏”，可以体会它比“乳糜”的液体更为稠厚，也就是从“乳糜”进一步变化成精液，然后渗入骨空，补益或滋生髓液，从而形成精又生髓的链式反应。从病证上可以反过来证明上述的道理，《灵枢·五癯津液别》又说：“阴阳不和，则使液溢而下流于阴，髓液皆减而下，下过度则虚，虚故腰背痛而胫酸。”它说明了男女房室过度，伤了肾精，精液流溢过度，势必致髓液减少（因为精能生髓），乃发生腰痛和膝胫酸楚等证。

津液除了化生血液、精液、髓液以外，又能内滋脏腑，变成脏腑之液，它有节制阳气，灌溉脏腑，以维持阴平阳秘的生理常态。至于五脏之气，所化生的五脏之液，如心之液为汗、肺之液为涕、脾之液为涎、肝之液为泪、肾之液为唾，也都由饮食分解而成，属于津液的化生，只不过它们的表现形式稍有不同，但它们之间的“血缘”关系则是一致的。例如：肝血可以化生眼泪，若泪流过多则伤肝血；肾精可以化生唾液，若唾吐过多则伤肾精。所以，不但“五液”如此相联，而精血之间，髓精之间，血髓之间都具有内在的相互转化关系，形成一条“津液链”而维系在一起。

根据“津液链”的结构与联系，精血之间、髓血之间、髓精之间就有一荣共荣、一枯同枯的关系。例如：血虚则精必减，精虚则血必亏，精虚而髓必干，髓干则血不荣。这是因为它们之间有同气连枝的内在关系，才有相互转化的物质条件。为此，“津液链”的学说不但突出了津液之间的联系性，同时，也反映了津液的整体观念，有助于中医津液理论

的发展。

明朝医家李中梓所著的《医宗必读》中载有“乙癸同源论”一文。他认为肝肾之所以能同治，是由于它们有“同源”的关系。肝藏雷火，肾藏龙火，皆赖于水的涵养而方能安居于下，根据这个道理，李氏把下焦的水作为“肝肾同源”的物质基础看待，从而在临床上提出肝肾可以同治的理论观点。但他提到津液之间的链式关系，对精、血、髓、脑实来源于津液的理论 and 它们之间相互转化的内核，则说得似明似暗，不够确切，令人读后有美中不足之感。若从临床治疗来看“津液链”的因果关系，有助于对这一问题的进一步理解。

病案一：

杨某，女，28岁。患者四肢与后背呈现游走性疼痛，按之不可得，两手掌鱼际部肌肉已见萎缩并有麻木感。饮食日减，厌食荤腥，并且口咽发干，不欲多饮，二便尚可。月经提前，量少，月经来潮则心烦不安。其面颊绯红，舌质红苔薄黄，脉大而软不任按。

此证由于胃液不足，而使胃气失调，故饮食日减，口咽发干。由于饮食少，津液亏，则不能化生营血。营血一虚则不能养肝，而使风阳发动，风阳走于肢体，消灼津液，则肌肉萎缩而游走作痛。经期则使血更虚，无以节制阳气，所以心烦而不安。治以滋养胃液，柔肝息风为法。

玉竹30克 石斛30克 白芍12克 生地12克 麦冬12克 胡麻10克 甘草6克 钩藤10克 石决明30克 何首乌10克

此方前后共服30余剂，而胃开能食，疼痛减轻，手掌鱼际肌肉渐长，诸证皆安。

病案二：

李某，女，25岁。症见：饮食减少，口咽发干，周身疲倦，时发烦热，夜寐不安。月经20天即潮，量少而色淡，使人更加疲倦，以致卧床不起。舌质红而苔净，脉细数无力。大便自调，小便色黄。

其人饮食减少，口咽发干而舌红苔净，反映了胃液不足，胃气失和；夜寐不安，时发烦热，而脉细数，则为阴血不足而阳热有余。血液源于津液，而津液又化生于饮食。今食少无以化液，断其来源则营血无从化生，故而经期体疲、卧床不起，治当滋胃液以增饮食，不补营血，而营血自生。

麦冬30克 玉竹30克 沙参15克 石斛15克 生地12克 茯苓6克 生扁豆6克

服六剂则胃开能食，诸证随减，转用固本汤：

生地10克 熟地10克 麦冬10克 天冬10克 炙甘草6克。

此方又服十余剂，身体从此逐渐康复。

从以上二则病例可以看出，凡胃液先虚，而使饮食减少，则营血无从化生而变虚。治疗不急于补血，更不是补气以生血，而以甘寒之品先滋胃中津液以养胃阴为先，务使胃气下行为顺。这种养胃滋阴之法，推而广之，于滋阴说中另辟蹊径，确有其临床意义。

4.“战汗”的发生、治疗及护理

“战汗”的出现，多见于急性外感热病之中。因其发作突然，寒战剧烈，不但病者惶恐不安，缺乏经验的医生也往往无从措手，甚至有时被误认为发疟，或怀疑治疗有误。现就有关“战汗”的辨治方法概述如下。

（1）战汗的发生机理

战汗发作时，往往先有寒战，战止而后发热，然后汗出热退，这是正邪互相交争的病情反映。因其正邪交争身发寒战，然后汗出，故称之为“战汗”。

战汗的发生，多因外感热病失治，邪气稽留，日久不出，须俟伏郁之邪渐溃，正气得到恢复，则正气抗邪发生战汗。《温疫论》说：“必俟其伏邪溃，表气潜行于内，乃作大战。精气自内由膜原以达表，振战止而复热，此时表里相通，故大汗淋漓，衣被湿透，邪从外解，此名战汗。当即脉静身凉，神清气爽，霍然而愈。”《伤寒论》太阳病篇指出：“太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗，汗出而解。”恽铁樵先生解释说：“振栗，即战汗也。”此为伤寒热病，邪留不解，阳气被郁，使脉道闭塞，所以寸尺之脉暂时停滞不见；阳气郁遏太甚，则必与邪气相争，正邪相争，故寒战振栗，最后正胜邪退，汗出而解。

也有病人正气怯弱，但尚有拒邪能力，而构成战汗机转的，例如《伤寒论·太阳病篇》说：“凡柴胡汤病证而下，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。”钱天来注释说：“蒸蒸，身热汗欲出之状也。振者，振振然动摇之貌，即寒战也。以下后正气已虚，难于胜邪，故必战而后汗也。”《伤寒明理论》说：“伤寒欲解将汗之时，正气内实，邪不能与之争，则便汗出而不发战也；邪气欲出，其人本虚，邪与正争，微者为振，甚者则战，战退正胜而解矣。”以上说明了在正虚的条件下，正气与邪气相争，如果出现战振的症状，也能达到汗解的目的，但同前面所述郁极乃发的战汗有所不同。一实一虚，应当加以区别。

《伤寒寻源》说：“战汗者，由里出表也，故往往有清凉攻下之

剂，绝不掺一毫表药，自得战汗而解者，此表里阴阳通达，阴阳交和，自然而然，而非可逼之使汗也。”说明在一定条件下，还可以促使战汗发生，非独限于某一种病证。

患者男性，年约30来岁，发热已六七日，时值初夏，其家人拘于感冒避风之说，竟关门闭户，复加衣被，患者弥增烦热，烦渴而欲冷饮，家人以忌生冷为由拒而不与。诊其脉大而有力，舌苔黄燥，面赤气粗，其人形体颇壮，审为阳证无疑，当即命人打开门窗，撤去衣被，并饮以新汲井水，一碗饮下，意犹未尽，又与一碗，三碗后，突然发生寒战，牙齿相击，得得可闻，周身耸动，把持不住。其家人甚为惶惧，以为咎由冷水。因而劝告：“此病为阳热实证，热势弥漫，形同火焚，即使使用白虎汤犹恐不足，饮以凉水，决无差错。现在发生寒战，是与室内清凉，水津内滋有关，说明伏郁之邪，将从战汗而解。况且脉象趋浮，决无危险可言。”大约20分钟后，则寒战渐止，通身大汗如同水洗，病人烦热顿释，但觉困倦思睡，乃嘱其家人谨慎护理，并疏小剂竹叶石膏汤加减，调理数日而愈。

从这一病例来看，饮以冷水原本是为润燥救液而设，开始时并未料及能发生寒战。也有寒战见于服药以后的，很难预料。

《伤寒六书》说：“战栗者，阴阳相争，故身为之战摇也，邪与正气外争为战，内与正争为栗，正胜邪得汗而解；邪胜正，遂成寒证矣。”《伤寒辨证》又说：“凡正气怯弱，寒邪在内，但心栗鼓颌而身不战者，已而遂成寒逆，似此证多不得解，以阴气内盛，正气大虚，不能胜邪，反为邪所胜，非姜附四逆汤、大建中汤与艾灸何以御之？”

由此可见，能战而汗出者为阳；战而不汗，与心栗内寒者，则又为阴盛之征，不能一概而论。总之，战汗的产生，为正邪互相抗争的反映，亦是邪热郁伏日久，出表作汗的一种形式，应该说这是病趋好转的一种可喜现象。

（2）战汗的辨证

战汗的寒栗症状，极为严重，如《格致余论》所说：“虽当炎月，若遇风霜，重棉在身，自觉凛凛战栗，禁栗动摇之貌如丧神守。”这种寒战症状，一般大约持续二十分钟左右，逐渐停止，然后发热，继而通身大汗。

战汗后的脉象，以浮缓为佳，因脉浮主于邪气外出于表，脉缓主于

胃气调和。如果战汗期间其脉闭伏而不见，不得惊慌认为脉气已绝，应当仔细观察患者的神气，如精神不败，气息调匀，乃是正邪交争所引起的暂时的脉闭，俟战汗透出之后，气血通畅，其脉自起；倘如战汗时，其脉促而气粗，肢体不仁，水浆不下，或突然发痉，两目直视，不能语言，则主正气涣散，邪气嚣张，多成危候。

战汗，以先战后汗，先寒后热者为顺，若单纯寒战，或心栗不止，而绝不见汗出者，则为阳虚阴盛，正气不能拒邪外出，治疗比较困难。如果同时出现神昏不省人事，眼前发黑而眩冒，也属正气垂危挣扎之象。

（3）战汗的转归

战汗为正胜邪退，大气周流之候，应以脉静身凉，神清气和，胸腹舒畅，渐思饮食，方为病愈之征。若战汗后，身热不退，脉仍急数，精神烦躁，胸腹满闷，不思饮食，则主余邪未尽，仍有再次发生战汗的可能。例如温疫病，往往是战汗一作再作，其病始解。

战汗后，若其人沉沉大睡，虽捱唤也不知醒，诊其脉和缓而有胃气，则属汗后正常现象，主大邪已解，正气正在恢复，嘱其家人勿令呼唤，由其酣睡，以复正气，无须治疗。

（4）战汗的治疗

正值战汗期间，一般不主张马上用药。因为正邪交争之时，阴阳相杂，病理变化尚不一定，如用温补过早，往往壅遏邪气，使汗出不彻；如用寒凉清下过早，则影响阳气的振奋，造成邪气不得外出。此时最好是频频进服热米饮，以壮谷气，以资津液，使正气充足，达到战汗作解目的。

如果其人六脉俱浮，纵然有昏冒之象，也是欲作战汗而解之兆，应当予热姜汤取其作汗，慎切勿妄投他药。

如果患者始终战栗而汗不出者，则必须凭脉辨证，找出不汗出的病理原因，及时治疗，以免发生其他变化。例如陈尧道曾说：“温病发战，凉膈、承气加生姜下之，必汗出而解；热病发战宜白虎合解毒汤；

有里证者，凉膈、双解散下之。”因热邪郁伏于内，不用清凉之剂，则不能迅速出表而为汗。若其人阳气素虚，不能蒸汗外出，可用温补之剂，助阳以透汗，如大建中汤、人参养荣汤皆可选用。也有精血亏损，缺乏作汗之资，则用滋阴生液之剂，以资其汗，如六味地黄汤合生脉饮，大剂多服，每获良效。总之，表气闭郁者，助以微汗；里热凝滞者，济以微下；阳虚者宜温；阴虚者宜滋。务使表里通畅，营卫条达，邪气出表，正气恢复，这是战汗的一般治则。为了说明阳虚不能蒸汗，和精血虚不能化汗的症状与治疗，这里选择先贤治案两则，以为临证参考之用。

病案一：

阳虚不能蒸汗外出的治例。张景岳先生治一老人患伤寒，初起即用温补之药调理，至十数日，正气将复之时，突然寒战，持续两个时辰左右，始终不得汗，寒栗不止，其势颇急。景岳用六味回阳饮加人参一两，姜、附各三钱，煎服下咽后，时间不久，即大汗如浴……

病案二：

精血虚不能作汗的治例。据《王止仲文集》记载：“一人病伤寒期月，体兢兢而振，齿相击不能成语。介宾以羊肉斤许熟之，取中大脔，别用水煮，良久，取汁一升，与病人服，须臾战止，汗出而愈。”

以上二案，或扶阳而“温之以气”，或滋阴而“补之以味”，皆为扶正而设，故能引邪外出，快汗而愈。若彷徨观望，坐失机宜，其病将不堪设想。

（5）战汗的护理

战汗发作期间，嘱其家人保持安静，安慰病人，精神勿令紧张，禁止家人恐慌喊叫，因为战汗属于正邪交战的过程，全赖心君坐镇进行抵抗，若精神遭受刺激，则心君被扰，势必降低正气的斗争力量，反使病邪得逞，而趋于恶化，不可不慎。

战汗时除饮以米饮或姜汤以助其正气外，并可根据季节而调整室温，夏季勿太热，冬季勿太寒。在汗出期间更应避免风寒侵袭，使其腠理不致闭塞，以免汗出不畅；汗出之后扑以温粉，固密玄府，以防汗出复受邪气。对于体弱或年老患者，在战汗时应观察色脉，预防虚脱，以备不测。

战汗后，大邪解散，正气也虚，应避风寒，慎起居，渐渐恢复体

力；若劳动过早，或饮食不加节制，每有劳复、食复等情况产生，临证时切须注意。

5.苏子降气汤证的病理特点及其临床运用

苏子降气汤方，始见于宋代的《和剂局方》，是临床上经常选用的一个方剂，其治疗范围比较广泛，使用得法，则效果极为明显。根据《局方》记载，本方主治：“男女虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，膈壅痰多，咽喉不利，咳嗽，虚烦引饮，头目昏眩，腰疼脚弱，肢体倦怠，腹肚^疝刺，冷热气泻，大便风秘，涩滞不通，肢体浮肿，有妨饮食……”以后的文献，如《丹溪心法》、《兰台轨范》、《医宗金鉴》，以及全国中医院校教材《方剂学讲义》等书，都以围绕《局方》的说法为准则，但也有一些方书，如《景岳全书》、《医方集解》、《成方便读》等，还曾提出本方有治疗风寒哮喘的事实。可见，在《局方》的基础上，利用它的疏肺利气，涤痰宽胸的作用，后世医家又赋予其新的主治内容。

（1）“上盛下虚”的病机特点

“上盛下虚”是苏子降气汤的病机特点，所谓“上盛下虚”，指的是肺气上盛而肾气下虚。根据中医理论，肺为气之主，而肾为气之根。气虽主于肺，其根则在于肾，因为呼吸之气主于肺，饮食水谷之气滋生于脾，先天生命之气则资始于肾。所以，肺主气，实为气之标，肾纳气，方为气之本。肺属金，肾属水，金能生水，而有“母子”之义，“呼出心与肺，吸入肾与肝”，阴阳升降，息息相通，则何病之有？但肾为水脏，内寄相火，如果水火相济，其气温焙，才能少火生气，充养周身。如果元气虚衰，或肾水不滋，相火过旺，则壮火食气，肺金胃火，则不能下藏于肾，此其一；亦有火衰水盛，水寒金冷，津液不得肾气之蒸化，留而为饮，上迫肺气，气不下肃，此其二。上述病理变化，前者是火旺灼金之喘咳，后者则为阳虚水寒，肾冷津凝之喘咳。而苏子降气汤的治疗当属于后者无疑。

（2）苏子降气汤的方义与作用

本方由苏子、半夏、厚朴、前胡、生姜、橘红、当归、甘草、肉桂九味药组成（一方有沉香无肉桂。我们认为两药皆用，疗效更好）。方中苏子、半夏、厚朴、橘红、生姜开胸降逆，利气化痰；前胡宣肺下气化痰；当归润燥养血；甘草安脾，调和诸药。妙在用肉桂以补君相之火，君火足则膻中阳振，膈上饮气自消；相火足则阳能化阴而痰饮得除。或加沉香暖命火，纳气入肾，而与肉桂相伍，治上盛下虚更为理想。此方有行有补，有润有燥，治上顾下，标本兼施，为豁痰降气，平喘理嗽，利胸快膈，通秘和中，纳气归元之良方。

（3）苏子降气汤的主治

苏子降气汤治疗“上盛下虚”痰喘咳嗽诸证，其中包括了近代医学的某些肺气肿、肺心病、慢性支气管炎等。根据本方的作用特点来讲，产生“上盛下虚”的病机可能有以下两种情况：

一种是《局方》所说的“虚阳上攻”，作为上盛下虚的病机。那就是由于肾阳的不足，下元虚寒、阴盛阳衰、阳被阴迫，而有“戴”、“格”之变。上攻的症状，既有上焦假热，如《局方》所说的“虚烦引饮，头目昏眩”等；又有阳虚津凝，痰气上涌的证候，如《局方》所说“膈壅痰多，咽喉不利，咳嗽”等证，这些症状的表现，归纳起来，统称之为“上盛”，这是虚阳上攻的上盛，而不是风寒遏肺的上盛。上盛是来于下虚，那么，《局方》所说的“腰疼脚弱，肢体倦怠，腹肚^疔刺……肢体浮肿”等证，就是“下虚”的体征表现。

另一种是感邪的上盛下虚。凡属下元阳虚的体质，容易感受风寒之邪。临床特点：咳喘多痰，恶畏风寒及头痛鼻塞等，兼见腰酸、腿沉、足冷、多溺、尺脉沉等，针对这样的上实下虚病情，苏子降气汤有上宣肺气，下温肾阳，正邪兼顾的特点。

上盛下虚之证，严重的可出现喘咳大作，痰涎壅盛，头痛汗出，四肢不温，小便多而带白，则属于阳虚“肾厥”的急证，急用本方将生姜改干姜，加人参浓煎，送服黑锡丹，有奇效。如果因咳喘久延，气机不顺，有升无降，血随气逆，浮溢于上，出现鼻衄、咳血、呕血等证，用本方加姜炭、黑芥穗、侧柏炭温经止血，理气平喘，则血自归经。

另外，喘咳气逆多有便秘不通，或排便困难之象，此属痰气蕴结膈上，津液不能下达，古人称为“气秘”。如果误认为胃肠燥结，滥施苦寒荡涤之品，徒伐胃气，反伤津液，通而复秘，于病无益。用本方降气以

达津液，使肺肠表里相通，大便不攻而自下。况苏子、当归皆有润肠作用，适当增加剂量更佳。老人及体质素弱者，加人参3~6克，推动气机下行，以增强排便的作用。如果命火衰微，痰湿特甚，肾气虚冷之便秘，用本方送服半硫丸立效。

上盛下虚还能出现小便不利、少腹胀满及下肢浮肿等证。用本方加桔梗6克、白蔻6克，以开提肺气，俗称“提壶揭盖法”；茯苓、泽泻各10克，以利水道。少加人参，佐肉桂以行气化，俾上焦得通，下焦得温，小便通畅，肿胀自消。

苏子降气汤治疗上盛下虚发生的梅核气病也颇为理想。本病一般为气郁痰凝，阻塞咽嗑，咯之不出，咽之不下，堵塞日久甚为痛苦。通常用小半夏汤、半夏厚朴汤等开郁理痰，便可获效。但如果属于上盛下虚的痰气凝结，便必须在本方基础上，肉桂减量用3克，另加桂枝6克，常能药到病除，效如桴鼓。因本方不但降气化痰，还能纳气归元，复借桂枝通阳宣痹，下气利咽之功，故能取效更捷。

苏子降气汤还能治疗胸痹疼痛。根据临床观察，胸痹疼痛，多为胸阳不振，痰饮内阻；或心肺气血不利，不通则痛。由于苏子降气汤有降气宽膈，豁痰宣肺的特点，凡辨证属于胸阳不振，阴气用事者，则加桂枝、薤白、菖蒲；痰浊交阻的，则加栝蒌、浙贝、枇杷叶（减去肉桂）；心肺气血瘀滞不利者，则加木香、郁金、延胡、枳壳。随证加减，奏效甚捷。

此外，苏子降气汤治疗痰气噎膈也很理想。此证多因忧思郁结，木郁气滞，痰涎交阻而食物难下；气不得下，津液不布，便秘不通。这样便会出现痰气愈结愈甚，津液亦必趋于日渐凝滞的局面。治疗方法必须开豁痰气的瘀结，以敷布津液的流畅，而用苏子降气汤，往往取得满意效果。

（4）病案举例

病案一：

王某，男，56岁。患喘咳病已十多年，近来加重。痰多色白，呼吸不利，咳逆倚息不得平卧。舌胖苔润，脉弦。初用苓甘五味姜辛汤，温肺化饮，敛气平喘，但药后平平，效果不明显。仔细诊察其脉，寸弦而两尺软弱，伴有尿多，神疲体倦，腰腿无力等证。辨为上盛下虚，肾不纳气，投苏子降气汤（肉桂与沉香并用），另加人参、冬虫夏草各6

克。一剂喘咳大减，即能平卧，神气大振。前后共服九剂，喘咳得以平息。

病案二：

武某，男，47岁。咳喘痰涌而胸满，咽喉不利。且头晕，心悸，气短，小便短少不利。舌胖大苔白，右脉沉细，左脉弦滑无力。右脉沉为肾阳虚，左脉弦为饮气，肾阳虚而不能化阴制水，水寒上泛而为饮，饮气阻肺，则成上盛下虚之势。

苏子10克 橘红10克 半夏10克 厚朴6克 前胡3克 生姜10克 当归10克 肉桂3克 人参6克 沉香4.5克 炙甘草4.5克 黑锡丹3克（冲服）

服二剂后，喘咳平而能卧。但仍头晕而痛，筋惕肉，小便不利，下肢浮肿，转用真武汤合桂枝甘草汤。

附子10克 茯苓30克 白术10克 白芍10克 生姜10克 桂枝10克 炙甘草6克

服二剂大效，小便利而肿消，头晕止。后以金匱肾气丸巩固。

病案三：

张某，男，69岁。外感风寒，续得咳嗽吐痰，痰多而黏，夜间小便频数，曾以苓桂术甘汤加陈皮、半夏等味治疗不效。其咳嗽以夜间及晨起为甚，且胸闷气短，难以续息，动辄更甚，饮食不佳。脉弦而舌苔微腻，舌质嫩红。按上盛下虚治之。

苏子10克 半夏10克 橘红10克 生姜6克 前胡6克 厚朴6克 当归6克 肉桂6克 沉香3克 茯苓10克 党参12克 炙甘草6克

连服五剂，咳痰明显减轻，食欲增进，但见胸闷气短而难以续息。又以苏子降气汤原方加红人参6克、沉香6克，服六剂而愈。

病案四：

韩某，女，38岁。西医诊断为风湿性心脏病。症见：心悸，气短，咳嗽痰多已四个多月。语言低微，面白不华，舌淡苔薄润，脉沉小数软。时当夏暑，仍着毛衣，自称身寒恶风，体疲无力。根据脉证分析，为肾阳不足，肺气复虚。阴来搏阳，故脉反小数。乃疏苏子降气汤，另加人参6克。二剂症状减轻，咳痰减少。以本方加减化裁，共服十六剂而恢复工作。

病案五：

吕某，女，37岁。4年来下肢浮肿不消，近半月又发现咽喉不利，如物梗阻，咳之不出，咽之不下，时时咳逆。并有胸满气短，头目眩晕，食欲不振，倦怠少力等症。其人面色黧黑，舌质淡胖，苔滑，脉沉

弦无力。开始辨为痰气郁滞的梅核气，用半夏厚朴汤无效。仔细思虑此证，脾肾之本先拔，浮肿多年不消，其痰湿不得运化，上阻肺系故见此象。徒利痰气之标，不治脾肾之本，所以无功，改用苏子降气汤。

苏子10克 半夏10克 厚朴10克 橘红6克 生姜10克 前胡6克 沉香4.5克
肉桂3克 当归6克 茯苓10克 泽泻10克 炙甘草6克

服三剂浮肿即消，咽嗑已不梗塞。原方出入，六剂而康。

6.温胆汤的临床运用

温胆汤是《备急千金要方》中的一张名方，主要用来治疗“大病后虚烦不得眠”。原方由竹茹、枳实、半夏、生姜、陈皮、甘草六味药组成。到了宋代，在陈无择所著的《三因极一病证方论》中，又在温胆汤原方中加上茯苓、大枣二味，但目前临床上一般不用大枣。《医宗金鉴·删补名医方论》认为本方主治“热呕吐苦，虚烦，惊悸不眠，痰气上逆”，并在《伤寒心法要诀·汇方》中以歌诀形式概括其主证为“口苦呕涎烦惊悸”。但现在临床上运用本方可以治疗许多病证，所以，有必要重新加以研究。

（1）方名考识

从温胆汤的药物组成来看，本方属于化痰清热，和肝胆，除虚烦，定惊悸的方剂，作用在于清而不在于温，与温寒暖胆的方剂明显有别。那为什么不把本方叫做“清胆汤”，反而叫“温胆汤”呢？中医认为肝属刚脏，性喜条达而忌抑郁，胆喜宁静而恶烦扰。《备急千金要方》说：“胆腑者，主肝也。肝合气于胆，胆者中清之腑也”，可见肝胆在生理上是相互沟通的。由于肝胆之气具有生、升的特点，以舒畅条达为平，古人将肝胆之气比类如春气之温和，温则胆气乃能条达。如果痰热邪气客于肝胆，则肝胆失其温和则发病。欲复其性，必先去其痰热，痰热去则胆气自和而温，因此用“温胆汤”作为方剂的命名。

（2）病因病机

温胆汤证的发病原因及机理，概括起来可以分为以下几方面：

1) 情志因素：

凡七情所伤，如恼怒，抑郁，思虑不决等，都能影响肝胆而使气机不利，不能顺其生长发陈之性，于是木气郁而土气不达，土气不达则易

生痰湿；气郁日久则化热，痰与热因气郁而交阻，则内扰肝胆为患。

2) 饮食内伤：

如嗜食肥甘，过于饮酒喝茶，以致素体痰湿壅盛，日久蕴而化热，内犯肝胆而成疾。

3) 外邪所伤：

如外受湿热，或被暑湿所伤，或大病后痰饮未消，余热未尽，痰热扰于肝胆而为病。

总之，痰壅气郁，肝胆失于疏泄，久而化热生火，以致痰、气、火三者交郁，就形成了“温胆汤”证。

（3）主治病证

温胆汤临床运用十分广泛，涉及多种病证，但根据临床所见，其主要脉证是：头目眩晕或疼痛，失眠，心烦，恶心，呕吐，心悸，胸胁胀满或疼痛，胆怯易惊。舌质红绛，舌体胖大，苔黄白而腻，脉弦滑或数。

其主证分析如下：肝胆风火相煽，挟痰热上扰，壅闭清阳之位，故头目眩晕或疼痛；肝胆气郁而失于决断，神魂无主，所以心悸而善惊；痰热内扰心神则烦躁不宁，失眠而多梦不安；木郁土壅，脾胃升降失常，往往出现泛恶欲吐，纳呆；肝胆气郁，使其经脉不利，则胸胁胀满或疼痛。

此外，痰为百病之母，更兼火性肆虐，病在少阳，枢机不利，气机升降出入失常，各种兼挟证比较多见，或挟湿热；或挟食滞；或挟阳亢，或挟风阳入络等证。

（4）临床运用特点

凡用温胆汤，一定要掌握其加减变化的基本规律，这是临床上运用本方治疗多种病证而取效的关键。

1) 柴芩温胆汤:

治疗少阳气郁化火，经气不利比较严重，如胸胁苦满或疼痛，口苦，目赤，偏头疼痛或气窜作痛等，加柴胡、黄芩，布达少阳气郁，发越少阳火郁，而能利少阳枢机。若胁下痞硬，加生牡蛎、川楝；胸胁疼痛引背者，则加片姜黄、南红花。

2) 黄连温胆汤:

治疗痰热扰心而热势较重，以心烦不安或失眠为主。火热重者再加黄芩，以清泄胆腑火热之邪。

3) 归芍温胆汤:

治疗少阳痰热而挟阴血亏虚。肝为藏血之脏，体阴而用阳。气郁化火，最易耗损肝血，血虚不荣则见头皮或肢体麻木，肢体拘急痉挛或肢颤，或周身窜痛，舌质红绛少苔或有裂纹，加当归、白芍滋养肝血；若头晕或头痛以月经为甚，上方再加白薇、党参；头胀痛者加夏枯草，巅顶头痛加川芎、白蒺藜，后脑痛加桂枝；阴虚严重而舌质光绛者，可加生地或乌梅。

4) 龙牡温胆汤:

治疗胆气虚怯，心神不宁所致的惊怖而夜寐不安，加龙骨、牡蛎可以敛神定志，同时加大茯苓剂量，以加强其安神的功效。严重者，可再加夜合花、夜交藤与龙齿。

5) 桃红温胆汤:

治疗少阳痰热而挟有血瘀脉阻，出现神呆或健忘，舌质有瘀斑，加桃仁、红花活血化瘀而通利血脉，严重者可再加川芎、赤芍。

6) 丹栀温胆汤:

治疗痰热内蕴，少阳相火郁勃，出现心烦不安或烦热汗出等，加丹皮、山栀以泄少阳相火。若五心烦热，加知母、黄柏；午后低热或盗汗加青蒿、地骨皮。

7) 郁蒲温胆汤:

治疗痰热蕴于胸膈，痹阻气机而见胸闷胸疼等，加郁金、菖蒲豁痰利气以开痹。若善太息或心中懊恼者，加佛手、香附；或由于痰湿上蒙心窍而出现神呆不语或语言不利者，也可加此二味豁痰开窍，严重者加远志、珍珠母、胆星、天竺黄等。

8) 苍柏温胆汤:

治疗痰热挟湿热下注，而见腰膝疼痛，尿黄短不利，妇女带下多等，加苍术、黄柏清下焦湿热。带下黄秽加土茯苓、椿根皮；湿邪重而厌食油腻者，加茵陈、滑石。

9) 黛蛤温胆汤:

治疗少阳痰热，相火郁勃而扰心犯肺，出现躁烦神狂多梦，或咳嗽痰多者，加青黛、海蛤壳清肝凉血，涤痰化结。痰多加瓜蒌仁、枇杷叶；吐痰不爽加海浮石。

10) 羚钩温胆汤:

治疗少阳痰热而挟肝阳上亢动风，眩晕耳鸣或昏仆，腰膝酸软，或肢麻、肢颤，加羚羊角、钩藤平息肝风。

11) 蚕蝎温胆汤:

治疗痰热动风入络而见肢体麻木，项强疼痛或肢体拘急痉挛者，加全蝎、僵蚕虫类搜剔之品以通经活络。

12) 硝黄温胆汤:

治疗少阳痰热而挟有胃家实滞者，症见腹胀满，大便干结或不爽，加大黄、芒硝或风化硝通腑泄热，以和胃气。

以上所举的12种兼挟证，常常伴随着主证而出现，主证与兼证在病机上有着内在的联系，如果能将以上所说的各种证治规律及特点熟记于心中，临证时审察病机之所变，病证之所偏重而加减变化不拘一格，则用方投药，多能取效。

（5）病案举例

病案一：唇舌感觉异常

杨某，女，59岁。得病已5年，屡治无效。自称其右侧唇与舌体感觉热而麻，如涂辣椒末，而左侧唇舌则感觉寒凉如冰。每日晨起必定先呕吐痰涎数口，而且心悸易惊，少寐多梦，舌苔白腻，脉弦滑有力。用温胆汤加胆星、竹沥、黛蛤散，服六剂后诸症全消。

病案二：心胸憋闷

张某，女，32岁。病从惊吓而得，心胸憋闷，有时气上冲胸，心中烦乱难忍，必须奔出户外，大声喊叫才觉舒缓。夜寐不佳，多梦，善畏，情志默然。舌质红苔白，脉沉弦。用温胆汤加郁金、菖蒲、香附、青皮、丹皮、白芍，服二十余剂，逐渐获愈。

病案三：幻觉幻视

王某，女，30岁。素常胆怯善惊，如果一人独居，往往幻见一屋老幼媚集，并向之吃吃而笑，非常森人。经常失眠，夜多噩梦，头痛，心烦口苦。舌质绛苔黄厚，脉滑数。用温胆汤加黄连、黄芩、龙骨、牡蛎、夏枯草、栀子等，进退十余剂而安。

病案四：身体振颤

朱某，女，21岁。平时胆怯易惊，少寐多梦。近日来每天午后周身振颤但无寒热，饮食尚可，经带也正常。只见面色黧黑，舌苔白腻，脉沉滑。此为痰气内郁，肝胆神魂不潜，挟有血虚动风之象。用温胆汤去甘草加钩藤、当归、白芍、熟地、香附、郁金、胆星，四剂愈。

病案五：失眠

张某，女，58岁。患失眠已有一个多月，经常感觉心中烦闷而难以入睡，或睡后乱梦纷纭，常被梦中景物所惊醒，心悸，闻声则惊。舌质红苔薄，脉弦。其证每因情志郁怒而加剧。用柴芩温胆汤加黄连粉、夜交藤、夜合花，服四剂即能安寐。

病案六：抽搐

周某，男，5岁。患小儿惊风，四肢不时抽搐，受惊吓后更加严重。舌苔腻，脉滑。用温胆汤去生姜、甘草，加天竺黄、天麻、钩藤、龙胆草、全蝎，连服五剂而抽搐止。

病案七：狂躁

武某，男，22岁。一年前精神受到剧烈刺激而患病。神情嘿嘿或多言不止，心烦不眠，时而狂躁不安，西医诊断为：狂躁型精神分裂症，

曾用中西药治疗而效果不显。大便干，舌质红绛，脉弦滑。证属阳火亢盛，挟痰扰心，用黄连温胆汤加大黄、郁金、菖蒲、青黛、海蛤壳，并送服紫雪丹。连服四剂，神志转清，言答正常。续用上方加减调治而愈。

病案八：眩晕

李某，男，41岁。头晕目眩，视物旋转，伴心悸，汗出，呕吐酸苦。舌质红苔白，脉弦细。用归芍温胆汤加白薇、石斛、石决明、龙胆草、生龙牡，服六剂而眩晕止。半个月后，天旱不雨，溽热袭人，病证又发作，上方加青黛、滑石、鲜荷叶进退而愈。

病案九：头痛

温某，女，27岁。患前额胀痛，伴头晕，泛恶欲吐已2年，近来发作频繁，每月2次。舌苔白腻，脉弦滑。用温胆汤加夏枯草、菊花、黄芩、当归、白芍。服药四剂，头痛若失。

病案十：热极似寒

王某，男，44岁。患者常觉有一股寒气从少腹向上冲逆，或向四肢滚滚流动，所到之处，寒冷麻木不堪忍耐。虽在炎暑烈日之下，也必须穿棉裤棉鞋才觉舒服。曾用附子一次量达30克也毫无反应。其人身材高大，双目炯炯有神，大便常，小便黄短，口苦恶心，胃脘作胀。舌苔白腻，六脉弦数有力。这是肝胆气郁，郁极化火，火极似水反见寒象。用柴芩温胆汤加当归、白芍、全蝎、青黛、滑石、龙胆草、栀子、青皮，前后加减共服九剂，寒流不作，身已觉温，能脱去棉裤棉鞋。后用四逆散调治。

7.加減木防己湯治療濕熱痺

加減木防己湯，出自吳鞠通《溫病條辨》，他說：“暑濕痺者，加減木防己湯主之。”“暑”，即為“熱”，所以“暑濕痺”即是“濕熱痺”。加減木防己湯是治療濕熱痺的主方，外感熱邪，與內濕相並，而致濕熱合邪為患；或素體陽盛有熱，感受外邪後易從熱化；或因風寒濕痺日久不愈，邪留關節經絡，郁而化熱，都可以導致濕熱痺。

自從《素問·痺論》指出：“風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，寒氣勝者為痛痺，濕氣勝者為著痺”以來，論治痺證莫不以風寒濕三氣為主。治行痺以散風為法，驅寒利濕為輔，方如防風湯；治痛痺以散寒為法，疏風燥濕為輔，方如烏頭湯，蠲痺湯；治著痺者，以利濕為法，祛風解寒為輔，方如薏苡仁湯等等。而對於“濕熱痺”的證治則逐漸湮沒不聞。

從臨床實際情況看，當今人民大眾多食膏粱厚味，又喜服性熱溫補之品，而使素體陽盛熱多，卒然感受風寒濕三邪，則從陽化而為濕熱，濕熱邪氣痺阻關節經絡，氣血不通，則形成濕熱痺。如《金匱翼·熱痺》說：“熱痺者，閉熱於內也……臟腑經絡，先有蓄熱，而復遇風寒濕氣客之，熱為寒郁，氣不得通，久之寒亦化熱，則瘧痺熿然而悶也。”

濕熱痺證，是濕熱相因為患，客於關節經絡之間，濕聚熱蒸，蘊郁不散，久而久之，經脈氣血受阻，運行不暢，因而成痺。臨床辨證多見肢節對稱性紅腫疼痛，活動不利，多伴口乾而渴，小便黃短，或發熱，或大便干結，舌質紅或絳，舌苔黃膩，脈滑數或沉滑有力等。治療濕熱痺證，以清熱利濕，宣通經絡為主要治法。

加減木防己湯是由《金匱要略》的木防己湯去人參加通草、杏仁、滑石、薏苡仁而組成。本方的特點是重用石膏，以清熱為主，配以滑石、杏仁、苡米清利三焦之濕熱；防己、桂枝宣通經脈之氣；通草能通利經絡關節之氣血。全方共奏清熱利濕，宣氣通絡之功，吳鞠通稱之為“治痺之祖方”。

病案一：

王某，男，15歲。患右踝、右膝關節紅腫疼痛已半年之久，嚴重影響活動。伴右腳底抽掣，右肩關節疼痛，大便素來干結，小便黃赤，口

干喜饮。舌质红，苔黄腻，脉滑数。血沉测定：50毫米/小时。

木防己15克 桂枝10克 杏仁10克 滑石15克 通草 10克 苍术10克 蚕沙10克 生石膏30克 苡米30克 海桐皮12克

上方加减服三十余剂后，关节疼痛明显减轻，血沉测定：25毫米/小时。上方又加赤小豆、金银花各12克，再服六十余剂，疼痛消失，活动自如，血沉测定3毫米/小时，从此病愈。

病案二：

索某，男，50岁。患两膝关节红肿热痛已多年，屡用驱寒散风等方治疗无效。其人小便黄赤，大便不爽，舌红苔腻，脉滑数。

木防己18克 生石膏30克 苡米12克 滑石12克 杏仁10克 通草10克 桂枝10克 片姜黄10克 海桐皮10克

服二剂则效，四剂肿消，六剂后疼痛消失。

病案三：

曹某，男，55岁。患坐骨神经痛。右臀下至大腿后与委中穴处剧痛拘急，不能步履，注射杜冷丁及普鲁卡因穴位封闭法皆不得效。舌绛苔腻，脉弦大，视其白睛带黄，询知小便黄短。辨为湿热痹，先服芍药甘草汤缓解筋脉拘急，后用：

木防己12克 海桐皮12克 生石膏30克 苡米30克 桂枝10克 杏仁10克 滑石18克 木瓜10克 通草10克 片姜黄10克 龙胆草10克

服六剂痛减其半，改用苍术、黄柏、木瓜、龙胆草、木通、柴胡、黄芩、知母、槟榔、当归、白芍、防己、车前子、泽泻各10克，六剂而痛止。

湿热痹在临床治疗的过程中，还要注意以下几点：

(1) 湿热相因为邪，纠缠不清，难以速去，治疗应抓住主要矛盾，守方守法。

(2) 湿热内蕴，不得外出，可见巩膜轻度黄染，但身不黄；或影响肺之治节，亦可见咳嗽、咯痰等。

(3) 石膏必须重用，热甚者配知母、金银花等增其清热之功；痛甚者加片姜黄、海桐皮增其化瘀宣络之效。

(4) 在治疗过程中，常可根据兼证加味治疗。如热伤营血而见皮下瘀斑者，加紫草、丹皮、生地等凉血之品；湿盛下注者加苍术、黄柏、龙胆草、木通等利湿之药；气血瘀滞者加桃仁、红花、乳香、没药等活血行气。

8.温病证治约言

温病的病证名称及治疗方法，在古人书籍中，名目繁多，初学者难以掌握。有鉴于此，特作《温病证治约言》一篇，从临床实际需要出发，少而精，以切实用。

（1）温热证治

1) 上焦

太阴温病，脉浮数，或两寸独大，尺肤热，头痛，微恶风寒，身热，自汗，口渴，或不渴而咳，午后热甚者，辛凉平剂银翘散主之；若咳甚而热不甚者，辛凉轻剂桑菊饮主之；若但热不寒，脉浮洪，舌苔黄，口渴甚，大汗，甚者面赤恶热者，辛凉重剂白虎汤主之。

若太阴温病由气及血，气血两燔，除见白虎汤证外，更有午后热甚等证，加减玉女煎主之；若气分之热迫血上行而作衄者，犀角地黄汤加银花、连翘、芦根主之；若温热之邪，由卫入营，寸脉大，舌绛而干，反不渴者，清营汤去黄连主之；若温热邪气郁遏营卫，发生赤斑者，化斑汤主之；若不发斑而发疹者，银翘散去豆豉，加细生地、丹皮、大青叶，倍玄参主之；温热由手太阴肺逆传心包，出现神昏谵语，舌蹇肢厥，或见痉厥抽搐，量其病情，酌用清宫汤、安宫牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹治疗。

安宫牛黄丸芳香开窍，咸寒清热滋阴，苦寒清热燥湿，为三宝中主将；紫雪丹于开窍之中能清中焦实热；局方至宝丹开窍辟秽，并滋肝肾，为三宝中次将；至于清宫汤，擅清膈中之热，且能滋水以制火，但不如三宝轻灵捷效，唯宜轻证。

2) 中焦

温热由上焦顺传中焦，阳明胃热津伤，但未成燥实，大便尚通，其脉洪滑，大热烦渴，喜饮凉浆，舌上干燥，或见黄苔，小便涩赤，呼吸俱粗，可用白虎汤治疗。若大便闭结，舌苔老黄，或黑干芒刺，脉反小

实或迟而有力，但热而不恶寒，反恶热，日晡热增，腹中疼痛，或绕脐痛，或手足汗出濇濇然，大承气汤主之。若上证具而病势轻微者，可用小承气汤主之；若谵语不大便，身无汗，腹不疼痛，加用紫雪丹治疗；若服后仍不大便，热不退者，酌用调胃承气汤。若阳明胃实兼见上焦痰热互结，其证大热大渴，舌燥，脉滑数，舌色金黄，痰涎壅盛，宜承陷合方治疗。若阳明胃实而脉虚，或应下而失下，正虚不能运药，用承气汤无益，可用新加黄龙汤为正邪兼顾之计；若肺胃皆实，右寸实大，痰涎壅滞，喘促不宁，肺气不降，地道不通，用宣白承气汤治疗；若阳明内实，兼有小肠、大肠热结，其证除大便不通外，尚有左尺脉牢坚，小便赤痛，时烦渴甚，用导赤承气汤治疗；若因温邪上闭心包，内窍不通，症见神昏谵语，大便不通，用牛黄承气汤治疗；若阳明胃实已下，二三日里证复现，但脉来无力，或见阳明可下证，但脉沉而弱，以及体弱津枯，老年肠燥，均以增液汤为主，或用调胃承气汤、增液承气汤。

阳明温病发黄，治同伤寒，总以茵陈蒿汤为宜。

3) 下焦

温热邪气，最易下伤肝肾之阴。或因中焦阳明土燥而竭少阴精水，或肾阴不滋，肝阳鸱张而动风发痉，必以大剂甘寒与潜阳之品急救其虚。若温邪久羁阳明，或已下或未下，身热面赤，口燥咽干，甚则齿黑唇燥，脉沉实者，仍可下之；脉虚大，手足心热甚于手足背者，加减复脉汤治疗；或温病误汗，津液被劫，心中震震，舌强神昏，仍用复脉汤治疗；若温热下耗下阴肾精，耳聋不聪，亦用复脉汤治疗。凡温热伤阴，口干咽燥，舌赤苔老，神倦欲寐，或热不为汗下所衰，六七日以外脉尚燥盛者，均应以复脉汤或救逆汤主治。也有温热伤阴，大便不摄而作溏泄，脉数而软，用一甲煎或一甲复脉汤；也有少阴温病，真阴欲竭，壮火复炽，心中烦而不得卧寐者，可用黄连阿胶汤，泻南补北，手足同治。若温热久居下焦，灼伤肝肾真阴而发为厥、哕，脉细而劲，用小定风珠治疗；若上证邪盛正虚，神倦瘈瘲，舌绛少苔，脉气虚弱，时时欲脱，急用大定风珠治疗。若少阴温病，脉沉数，舌干齿黑，手指但觉蠕动，急防痉厥；或已成痉厥，脉细促，心中憺憺大动，甚则心中痛者，用一甲复脉、二甲复脉、三甲复脉汤，酌其证情之轻重而用之。凡少阴温病，夜热早凉，热退无汗，热自阴来，用青蒿鳖甲汤治疗有效。

(2) 暑温证治

1) 上焦

手太阴暑温，寒热无汗，右脉大于左，舌苔白略腻，用新加香薷饮治疗；若见汗出，口渴饮凉，脉右大而数，用白虎汤治疗；若身重或疼，下肢厥冷，小便短少，用白虎加苍术汤治疗；若暑热伤气，汗出甚多，脉大无力者，用人参白虎汤；汗多脉散大，喘咳欲脱者，用生脉饮治疗。一般暑热，寒热烦渴，小便涩短，或泄利，用益元散凉水冲下。

暑温上犯心包，治与温热同。

2) 中焦

阳明暑温，热结化燥者，按承气汤证治之。

暑多挟湿与痰水，阻碍三焦，影响气机。若脉洪滑，面赤身热头晕，不恶寒但恶热，舌苔黄腻而滑，渴欲凉饮，但得水则呕，胸下痛，小便短，大便闭者，为水结在胸，小陷胸汤加枳实治疗。若痰热凝聚，心下痞满，不饥不食而又不大便，脉滑数，用加减半夏泻心汤治疗。若暑温漫延三焦，不拘一处，其证但以肺胃为主，呕、渴、心下烦满，小便少，下利，或发热等，可用三石汤治疗。若舌苔不滑，黄而灰白，胸中痞闷，烦渴自利，汗出尿短者，用杏仁滑石汤治疗。

3) 下焦

暑犯下焦，证有虚实之分。

如暑邪与在里之水湿搏结在肝经，其症胁痛，或咳，或寒热如疟，或但潮热，不得作柴胡证，轻者用香附旋覆花汤治疗；重者用控涎丹治疗。若暑邪而发生蓄血或热入血室证，治与温热同，此属实证方面。

若暑邪深入少阴而消渴者，用连梅汤治疗；暑邪久入下焦，消灼真阴，兼伤元气者，可用三才汤治疗，或参以复脉汤等法；若暑邪下犯厥阴而发生身体麻痹者，也用连梅汤治疗；若舌苔灰而消渴，心下板实，呕恶吐衄，寒热下利血水，甚则声音不出，上下格拒者，椒梅汤治疗，此属虚证方面。

(3) 湿温证治

1) 上焦

湿温为病，头痛，身重酸疼，寒热，胸闷不饥，午后身热，泛恶，小便发黄，脉弦细而濡，舌苔白不渴，用三仁汤治疗；太阴湿温气分闭郁而呃逆者，用宣痹汤治疗；咳喘者，千金苇茎汤加杏仁、滑石治疗。

湿温犯心包，神昏谵语，治同温热，唯用清宫汤法减去滋腻之品，如麦冬、莲心，加入金银花、赤小豆皮清热利湿之品。

2) 中焦

湿温病在中焦较为多见，其机制在于湿困中州，气机不利，每见脘腹胀满，饮食不运，二便失调等证。酌其湿与热孰多孰少，选用加减藿香正气散治疗。如湿困三焦，小便不通，渴不多饮，呕逆身痛，头重且胀，神识昏迷者，先用安宫牛黄丸芳香开窍，继用清淡分消湿浊之法，如茯苓皮汤，即所谓“治湿不利小便非其治也”。若湿热两伤，脉缓身痛，舌淡黄而滑，汗出热退，继而复热，小便黄短，当以黄芩滑石汤清利湿热；若湿阻中州，胃气不和，与饮相搏，呕而不渴，小半夏加茯苓汤治疗；若胃气上逆为哕者，新制橘皮竹茹汤治疗；若呕甚而心下痞者，用半夏泻心汤去人参、干姜、大枣、甘草加枳实、生姜汤治疗。若中焦湿热发生黄疸或水肿者，如二金汤、茵陈五苓散、杏仁石膏汤等，以达到表里两解，三焦统清，纵横开阖，使湿热得解，黄疸可退。湿证复杂，治法颇多，如能先掌握住以上诸法则为基础，由是循序而进，便有得心应手之妙。

3) 下焦

湿温久羁，弥漫三焦，神昏窍闭，少腹硬满，大便不下，用宣清导浊汤主之。若湿与气搏，既伤且阻，三焦不利，二便不通，可用半硫丸治疗；若浊湿久留，脾肾两伤，舌苔腐白，不喜饮食，尻肛作痛，大便下坠，重而难通，脉沉而缓，可用术附汤治疗。湿为病亦能继发疟痢等证，按疟痢常规治疗。

（4）秋燥证治

1) 上焦

燥热初袭肺胃，左脉数大，咳嗽咽干，苔白边红，治用清燥汤；若伤肺胃之阴，发热而咳，口中干燥，用沙参麦冬汤治疗；若燥伤肺胃，气_贲作咳与喘，咯白黏痰，夜发为重，用喻氏清燥救肺汤。

寒燥亦称凉燥，初伤肺卫气分，咳嗽稀痰，头痛，微恶风寒，鼻咽阻塞，脉弦无汗，舌苔白而润，用杏苏饮治疗；若燥伤肺金，逆及肝木，其症头痛寒热，胸胁疼痛，甚则变生疝瘕，柴胡桂枝汤加吴茱萸、川楝子、茴香、木香治疗。

2) 中焦

燥从热化而成阳明里实证，按伤寒法治疗；若未热化，而成寒燥津凝，大便不通，其脉短涩，面青黄，苔不黄燥而多滑腻，治用大黄附子汤或新方天台乌药散。

3) 下焦

燥气入下焦，搏于血而成癥者，无论男妇皆用化癥回生丹治疗。若下焦阳虚，六脉不足，寒燥下伏，则少腹胀痛有形，痛止则消散，可用复亨丹治疗。

(5) 结语

伤寒和温病，是治外感热病的两大系列，寒温迥异，证治各殊，切不可偏执，或混为一谈。世之医家，有重伤寒而废温病，有重温病而废伤寒，更有甚者，以伤寒之法治温病，以温病之法治伤寒。寒热不辨，温清不分，以致延误病机，变证迭出。仲景之书，为万世立法，其六经辨证论治体系，不独为外感风寒而立，也能用治杂病。但温病证治，大有别于伤寒，所以欲在临床上立于不败之地，也需精研温病之证治。清人吴鞠通作《温病条辨》，病名列风温、温热、温疫、温毒、冬温、暑温、伏暑、寒湿、湿温、秋燥等十种，分列三焦证治，共二百三十八法，一百九十八方，论治温病甚详，为后人所推崇。但其方法繁多，印之于临床，也令人难以掌握。现将其书中精要之处，总结归纳，又不失其义，病名列温热、暑温、湿温、秋燥四种，按三焦分治，简短扼要，可为初学者的借鉴。

9. 阴虚性肝胃不和的证治

在临床上，一提出肝胃不和，往往指肝气郁结犯胃，引起胃失和降而言，对此，似乎没有什么可以议论之处。但是，另有一种“阴虚性的肝胃不和”则恰恰相反，认识它的人还不够广泛。这种病的症状，同一般的肝胃不和看来很相似，所以诊断时容易混淆不清，在治疗上，也易犯用燥药反劫肝胃之阴的错误。

首先应该说明，这里所指的“阴虚”，是指肝血和胃液不足，因为肝血胃液，都有节制肝胃气、阳的作用。如果肝、胃阴虚，不能节制气阳，则可导致肝气横逆，而使胃气不和。叶天士说：“厥阴之气上干，阳明之气失降”。可见肝胃阴虚的肝胃不和，有其特殊性，不能与一般的肝胃气不和混为一谈。为了进一步说明阴虚性肝胃不和，现从病因、病机、辨证治疗及临床医案几个方面来加以论述。

（1）病因

可以导致阴虚性肝胃不和的病因较广，举其常见者，有以下几种：

1) 肝阴虚的病因

肝气：肝气以条达疏泄为顺。如果由于情志因素，而使肝气抑郁不疏；或暴怒气上，激发肝阳，皆能化火而伤肝阴。

饮食：偏嗜辛辣，或过服温燥之药，或以酒为浆，则能助阳化火而伤阴。

劳役：凡久视而伤肝血，房劳过度而伤肾阴，或产乳过众而耗血液，皆能使肝阴匮乏而生病。

外感：六淫之邪皆能化火，尤其是温热之邪，最易内入营血而耗其阴。

2) 胃阴虚的病因

情志：五志过极化火，内耗胃阴，势如焚羔，不竭不止。

饮食：同肝阴虚。

外感：传经之邪入里化燥而伤胃阴。

误治：汗、吐、下运用不当，皆能内耗胃液。

病后：伤寒大病愈后，往往出现胃阴不足。

（2）病机

1) 肝：

《素问·阴阳应象大论》说：“东方生风，风生木，木生酸，酸生肝……”说明肝脏有风木特性，故称“风木之脏”。肝木禀受春气，而有生、升的特点，因与少阳为表里，中寄相火，阴中有阳。朱丹溪说：“阳常有余，阴常不足。”肝阳之用，在某种情况下，容易过极；肝阴之体，在某种情况下，又容易不足。但是，人体脏腑的阴阳气血，在正常情况下是互相制约的，肝的气阳只能驯伏而不能太过，这是因为上焦有肺气肃肃下降，中焦有胃液滋溉，下焦有肾阴潜涵，三焦为水谷之道路，津液流布，所以肝阳不能不潜，而肝气也不得不柔。

至于血液节制肝阳、肝气的作用，比上述各脏更为明显和重要。

《素问·五脏生成》说：“故人卧血归于肝，肝受血而能视。”如果肝不受血，则目也不能视，可见血对肝的重要性。以此推论，肝血不但荣于目，而且能制约肝气的横逆，制约阳气的过亢，制约肝风的发动，如此种种，可以连类发明。

以上这些认识，为肝血虚所致的肝气不和，以及在治疗上用血药养肝而不用气药疏肝，制定了相应的理论和方法。

2) 胃：

胃属阳明，“两阳合明谓之阳明”，标志着阳明处于两阳之间，阳气非常隆盛，所以负有腐熟水谷的作用。阳明恶燥喜湿，与太阴相表里。胃阳虽盛而不致亢奋无制，是因为有太阴津液的补充，所以胃气得以下行为顺。如果胃液不足，盛阳无制，则燥气得逞。叶天士提出了“胃汁竭，肝风动”的理论，不但重视胃阴，而且还认为胃阴虚可以发动肝风

为患。治疗时主张用甘寒滋润药物，如益胃汤，从而补充了李杲偏重甘温补脾所致的不足方面。

通过长期的临床研究，针对阴虚性肝胃不和的特点，我们研制了“柔肝滋胃饮”与“益胃和肝汤”辨证论治，颇能得心应手。

（3）辨证治疗

1) 肝阴虚为主的肝胃不和证治

主要脉证及舌象：胸胁满闷，胃脘痞胀或疼痛，噎气或呃逆，脉弦细数，舌红绛少苔或无苔。

兼证：口咽发干，以晨起明显，不欲饮食，大便不爽或溏泄，心烦寐差，或兼见低热。

证候分析：血虚则不能柔养肝体，肝失血养，变柔为刚而使肝气不和。肝横气逆，胃当其冲，所以见证与一般的肝胃不和颇为相似，但是舌绛无苔，脉弦细以及一派阴虚津亏的见证，与一般的肝胃不和不同。

治法：柔肝、滋胃、调气。

方药：柔肝滋胃饮。

沙参 麦冬 玉竹 生地 白芍各10～15克 川楝 佛手 橘叶 丹皮各6～9克

方解：川楝、佛手、橘叶疏肝理气而不伤阴；丹皮、白芍平肝凉血以制肝横；沙参、麦冬、玉竹、生地能滋胃柔肝以养阴血之虚。

加减法：

胸咽堵塞加贝母、郁金、枇杷叶、射干等宣肺利咽之药；

头目眩晕加菊花炭、珍珠母、石决明等平肝潜阳之品；

恶心呕吐加枇杷叶、竹茹、荷蒂等和胃降逆；

不欲饮食加生扁豆、生谷芽、川石斛等滋养脾胃以生发谷气；

大便泄泻去生地，加生牡蛎、生山药等药健脾以固肠胃。

2) 胃阴虚的肝胃不和证治

主要脉证及舌象：口咽干燥，胃中灼热但饮水不多，食减，厌食荤

腥而喜食清淡，大便或溏或燥。舌质红绛，无苔或少苔，脉弦细数。

兼证：胸脘胀满，噫气不除。

证候分析：胃阴虚则津液不能上承，故口咽干燥；胃液不足则阳热上熏，故食减而厌荤腥；胃中津液不调，所以大便或溏或秘。至于胁脘胀满，噫气等证，无非肝失疏泄，气机逆乱的结果。

治法：滋胃阴，和肝气。

方药：益胃和肝汤。

沙参 麦冬 玉竹 生地 白芍各15~18克 枇杷叶 川楝 郁金 荷蒂 丹皮各6~9克

方解：沙参、麦冬、玉竹、生地滋养胃阴以柔肝气；丹皮、白芍平肝凉血；川楝、枇杷叶、郁金、荷蒂清降胃气，条达肝气以治胀满，噫气等证。

加减法：

胃中灼热加大剂量石斛、黄精、山药以敛其阳热之气。

胃脘疼痛加延胡、郁金、绿萼梅、佛手等调理气血以止疼痛；

大便溏泄加牡蛎，甚者加乌梅；

心烦寐差加夜交藤、夜合花。

（4）病案举例

病案一：胁脘胀满

李某，男，35岁。患慢性肝炎已有2年。两胁胀满疼痛，脘腹作胀，暖气则舒，饮食日减，口咽发干，大便溏泄，每日2~3次。自述服中药二百余剂而不见功效，所视其方，皆香燥疏肝理气之品。视其舌光绛无苔，脉右弦滑，左弦细。

川楝9克 贝母9克 荷蒂9克 青皮9克 木瓜9克 沙参30克 麦冬30克 黄精30克 白芍6克 炙甘草9克

服药三剂后，诸症均有明显好转。方中又加乌梅2个，再服五剂，症状已基本消除。

病案二：不能食

吴某，男，32岁。患胃病一年有余，不能食，强食则胃脘发胀，呃

逆而胃中汩汩然有声。口咽发干，尤其以睡醒后为甚。且大便作泻，每日数行，形瘦体惫。有医按脾虚治疗，投以人参健脾丸，诸症未止，又添梦遗，脉弦细，舌光红如锦。知其阳用太过而又误用温燥，助阳为火，反更伤其精。

玉竹15克 生地15克 麦冬15克 沙参15克 山药19克 木瓜6克 川楝9克 牡蛎12克 石决明12克 粳米9克 冰糖6克

服此方如法加减，共三十余剂，始能饮食如常而诸症亦消。

病案三：胃脘疼痛

吕某，男，48岁。患十二指肠溃疡，胃脘疼痛以食后为甚，饮食减而大便溏泄，每日七八次。服用温中理气之药反而加剧。舌红绛而干，脉弦但按之软。

沙参 麦冬 玉竹各12克 白芍9克 甘草6克 山药15克 茯苓9克 荷蒂9克 川楝 延胡各6克 珍珠母12克

初服五剂，疼痛大减。守方进退二十余剂而饮食渐增，大便基本转常，舌红而生白苔，改用参苓白术散制成蜜丸巩固。

病案四：下利腹痛

曲某，女，48岁。1969年经北京某医院确诊为“乙状结肠癌”而行手术治疗。一年后，陆续出现术前证候，两侧少腹疼痛以左为甚，大便下利每日四五次，呈棕色或如橘皮色，黏液甚多。食减，呃逆暖气，舌红绛苔薄白，脉沉弦滑。此为肝气化火，迫胃肠津液下注为利。

川楝 佛手 荷蒂各9克 绿萼梅6克 石斛30克 麦冬15克 白芍18克 炙甘草9克 玉竹 沙参各9克 藕节6克。

服药六剂后，下利与呃逆皆有明显减轻。上方又加青皮、丹皮、山栀、贝母等药服十二剂，症状消失。

10.益胃汤的临床运用

益胃汤法原出于叶天士《临证指南医案》，经吴鞠通归纳总结后，提出“益胃汤”这一方名，他认为：“盖十二经皆禀气于胃，胃阴复而气降得食，则十二经之阴皆可复矣。欲复其阴，非甘凉不可。汤名益胃者，胃体阳而用阴，取益胃之用义也。”

本方由沙参、麦冬、生地、玉竹、冰糖组成，以甘凉柔润之法滋养胃阴，是益胃滋液的代表方。临床上用来治疗胃阴不足所致的多种病证，疗效卓著。外感温热病过程中，热邪最易耗伤胃阴，胃阴一伤，则上不能滋肺，中不能柔肝，下不能滋肾，由此可发生各种病症。其他如温病误用汗下，或素嗜辛辣，也容易使胃阴受损。所以，益胃汤治疗胃阴虚就极有临床意义。

病案一：

叶某，男，40岁。身高体魁，但食量甚少，每日只进食250克（四五两），且不喜肥甘之味。胃中隐痛时作，大便干燥，夜寐欠佳，晨起口咽干燥。舌红绛少苔，脉弦细而数。此胃阴虚而津液不足使胃气不得下降，所以谷物不得纳入。

麦冬18克 玉竹15克 沙参15克 生地10克 石斛30克 白芍10克 牡蛎12克 甘草6克

按语：不欲食一症，临床多从胃气虚弱入手，但也有不少是属于胃阴虚的不欲食，须以甘凉滋液为法，吴鞠通说：“胃阴复而气降得食。”胃津不能上润则口咽干燥，或喜饮；阴不足不能和阳，阳不得入于阴则夜不安寐；胃中津液不能下濡肠间，故大便干燥。有形之阴不能速生，治疗时应谨守其法，须缓缓图治。

病案二：

孟某，女，2岁。症见咳嗽，低热，盗汗，不欲食而反喜饮水，舌红苔薄，脉数。此胃阴虚而肺系失润，主以益胃之法。

沙参6克 麦冬6克 玉竹6克 生地6克 冰糖一块 牡蛎10克 糯稻根15克
上方共服二十余剂而愈。

病案三：

陈某，男，52岁。素有胃疾，近日大便潜血，胃脘疼痛，不欲饮

食，食后则胃疼更甚，口干，舌红少苔，脉滑数。证属胃阴不足，不能制阳而生内热，热又伤及阴络而动血。

沙参15克 麦冬15克 玉竹15克 鲜生地30克 石斛 15克 扁豆10克 苡米10克 藕节15克 桑叶10克 竹叶10克

服六剂，血止而痛去。减去藕节、桑叶，又服十余剂而饮食渐增。

病案四：

庞某，男，28岁。大便不调，每日三四行，甚或十多次。所奇者，大便后又泻出棕褐色油脂，时多时少，偶或矢气，往往同油脂迸出。肛门灼热，有下坠感。舌红苔黄，脉弦大。此乃胃肠阴虚，又被肝胆之火劫逼肠脂下注。

麦冬18克 沙参10克 玉竹10克 生山药24克 生石膏12克 白芍18克 乌梅3克 黄连3克

服五剂而病证减半，大便调而油脂减少，续上方进退十余剂而安。

按语：胃阴不足，大肠失于濡润，大便多以干燥难下为主。如果在一派胃阴虚见证基础上，而见大便反泻，则应考虑肝胆之火逼迫阴液所致，常常有里急或下重感，稍不及时则粪污衣裤。在这种情况下，治疗往往是去生地之滋腻，而加乌梅、白芍等酸收之品，一方面预防津液下脱，另一方面又有敛阴柔肝之用。

病案五：

唐某，男，38岁，患脱肛已有二年多，大便干燥。伴腹满，暖气，食少，口干，寐差等症。舌红少苔，脉弦细。此肺胃阴虚，津液不能下达；复加肝郁而疏泄不利，横伤脾气则下陷而脱肛。

沙参12克 麦冬18克 玉竹12克 生地12克 百合10克 白芍18克 木瓜6克 甘草6克

服三剂，脱肛症明显减轻。又加乌梅、诃子、黄连，服十余剂而愈。

按语：此证大便干燥，腹满，不食，似乎属于阳明腑实，但舌红少苔，脉弦细，所以知胃阴虚而肝气逆。阴虚不润则大便干燥，肝气横逆故腹满而暖气。如是阳明腑实，必有燥屎内结等大实证，舌苔当黄而干，甚或焦黄。其证虽有相似之处，但虚实之间，不可不辨。

总之，临床运用益胃汤，一定要紧扣胃阴不足这一病理特点，辨证以口咽干燥，不欲饮食或不喜肥甘，大便干燥而胃疼，舌红绛少苔或苔薄，脉细数或弦细等为主。大便出血者加藕节、桑叶；大便泄泻而里急

者加白芍、乌梅、黄连；脱肛加诃子、木瓜；胁痛加牡蛎、片姜黄；咽痛加玄参、青果、桔梗等，俱有效验。

11.三甲复脉汤的临床运用

三甲复脉汤是治疗厥阴阴虚导致虚风内动的一张名方，无论外感或内伤皆可用之。但是，三甲复脉汤证是怎么产生的？其临床运用有什么特点？应该注意什么问题？因此，如何正确地认识本方的组方特点及其临床运用就显得很有意义。为了便于通俗地阐述和理解，先请看下面的两则验案：

病案一：

某，男，56岁。患者身材魁梧，但却常常头晕欲仆，耳鸣如蝉，心悸不安，心烦而夜不安寐，时或鼻衄。舌红少苔，脉沉弦有力，偶有结代脉象。

龟板18克 牡蛎18克 鳖甲18克 生地18克 麦冬18克 白芍18克 麻仁12克 阿胶10克 炙甘草12克

服二剂后心神安宁而思睡，头晕耳鸣等症大为减轻。又以大定风珠四剂而安。

病案二：

李某，女，43岁。有风湿性心脏病史五年，近日来头目眩晕，肢体颤动，站立不稳，心悸不宁，神乱少寐。舌红少苔，脉沉取弦细，举之则大而无力的。

炙甘草12克 党参12克 桂枝6克 大枣7枚 生地30克 麦冬18克 白芍18克 麻仁18克 阿胶10克 龟板18克 鳖甲18克 牡蛎30克

服药一剂则能安卧，肢颤止，眩晕减轻，能自行步走。但有纳谷不香而脘闷，方中加米醋一大盅，又服三剂而证消。

从这两个医案中可以看出以下二点：其一，二案皆有厥阴阴虚，不能涵养肝木，水不制火，阴不潜阳而风阳内动之象，所以治疗皆以滋阴潜阳息风为法，即三甲复脉汤法。其二，案一的脉象沉弦有力，脉证相应，符合病机；而案二的脉象则表现为按之弦细，举之则大而无力的，结合其病史，可知其人素来心阳之气亦虚，因而病机就变得更为复杂，如果单纯用益阴方法则有碍于阳气的流畅，所以在方中加上参、桂、枣等甘温之品，一方面扶助心阳之气，另一方面还有活泼气机，阴阳并调之妙。所以，实际上案二是取法于仲景炙甘草汤。那么，三甲复脉汤和炙甘草汤之间又有什么联系呢？接下来就谈谈三甲复脉汤的产生及组方特

点。

三甲复脉汤实际上是源于张仲景的炙甘草汤。由于炙甘草汤主治“心动悸，脉结代”，所以又称为“复脉汤”。复脉汤既能补心血，滋心阴，又能益心气，通心阳，为气血双补，阴阳并调的方剂。但是，温病以温邪伤阴为主，病至后期，手足厥阴之阴液被温邪所耗伤，风阳妄动，表现为手足心热甚于手足背，口咽干燥，神倦欲寐，或心中震震，舌强神昏，脉虚大或结代等，所以，以复脉汤去参、桂、姜、枣之阳药，加白芍收敛阴气，以复厥阴之阴液为主，就叫做加减复脉汤。吴鞠通说：“在仲景当日，治伤于寒者之结代，自有取于参、桂、姜、枣，复脉中之阳；今治伤于温者之阳亢阴竭，不得再补其阳也。用古法而不拘用古方，医者之化裁也。”如果在此基础上，又出现心中憺憺大动，甚则心中痛者，则在加减复脉汤中加牡蛎、鳖甲、龟板三味，就成了三甲复脉汤。本方以大剂甘润滋阴的药物为主，补益厥阴津液，同时，加入三甲有滋阴潜阳的功效，使阴能制阳，水能济火。

临床运用三甲复脉汤，要紧扣厥阴阴虚，风阳内动这一病理特点，其辨证特点以头晕、心悸、肢体抽搐或痲疯，舌红绛少苔或无苔，脉弦细或结代为主。或头痛耳鸣，神倦而夜寐不安，或昏眩欲仆，步履不稳，或厥，或舌体颤动，语言不利而肢麻，或大便干秘难行等。治疗范围涉及脑膜炎后遗症、癫痫、小脑病变综合征、帕金森综合征、心病、精神分裂症以及各种以眩晕、抽搐为主要临床表现的病证。

病案三：

郭某，男，14岁。患脑膜炎后遗症，右侧头痛，眩晕而两目视物不清，每隔数日发生痉厥一次，始则头面发麻，继而两手抽搐。患儿形体较瘦，面色苍白，平素大便干而小便黄。舌体右斜，舌质红绛，脉弦直而数。

牡蛎15克 鳖甲18克 龙骨15克 生地30克 阿胶10克 鸡子黄2枚 麦冬24克 白芍15克 炙甘草10克 五味子3克

服药约半月余，颇见功效，痉厥减发，诸症亦轻。一日西医内科大夫查房，因其大便干燥，而以硫酸镁泻下，大便六七次，纯为水液样粪便。泻利后，入夜则头痛、身麻，两手抽搐加剧。此因误下而重伤阴液，仍主三甲复脉汤、大定风珠等滋阴拯液，柔肝息风。两周后，情况显著好转，患儿已能下床玩耍，且食量大增。上方又服至二十余剂，诸症基本痊愈出院。

温热病后期，以阴液亏虚为主，切不可因其大便干燥而滥施下法。即或要用下法，也必须要有可下之证，张仲景说：“少阴病，六七日，

腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。”又说：“少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜大承气汤。”从一“宜”字可知，即便有可下之证，犹当推敲斟酌，但得大便通则止，不可猛浪过泻。

病案四：

沈某，女，31岁。素体脾胃虚弱，运化无力，食少体疲，头晕而便干，月经后期而量少。入冬之时，不慎外感，经治后表证已解，但遗低热（37.5℃）不退，并添舌体颤抖而齿击有声，伴心悸、失眠等症。某医按心脾两虚治疗无效，反增口舌干燥。舌红少苔，脉弦细。此为肝阴虚而风阳发动，治当柔肝息风，养血安神。

白芍15克 生地15克 石斛15克 珍珠母30克 钩藤10克 白薇10克 当归10克 茯神15克 夜交藤30克 黄连6克 另研琥珀、朱砂各3克，分4次冲服。

服药后心悸大减，夜能安寐，但舌颤齿击未效。转用：

龟板15克 牡蛎15克 龙骨15克 珍珠母15克 麦冬24克 生地18克 白芍12克 丹皮10克 阿胶10克 鸡子黄2枚 五味子3克 炙甘草10克

服药三剂后，舌颤齿击均止，大便畅通而神爽。上方加玄参、酸枣仁各15克，续服七剂巩固之。

病案五：

赵某，男62岁。每于夜间睡眠之中，突然惊叫而身体乱动，手足躁扰，曾用镇静药治疗无效。大便干燥难下，舌质红绛而苔薄黄，脉弦大。此为肝肾精衰，阴气不足以制阳，阳不入阴而亢动，欲成痉厥的先兆。

龟板15克 鳖甲15克 牡蛎15克 龙骨15克 麦冬30克 石斛30克 生地15克 白芍15克 丹皮12克 玄参12克 元明粉6克 甘草10克

服药后大便畅而夜惊止。上方去元明粉，再服，共进约三十余剂而病安。

病案六：

朱某，女，45岁。患病抽搐已十五年。每夜入眠后，突发心悸不安，继之手足抽搐，周身发麻。腹胀大如孕状，周身浮肿，口咽发干。舌红绛无苔，脉沉滑。值经期则病剧，每夜可发生二三次。

龟板30克 鳖甲30克 牡蛎30克 白芍18克 生地30克 麦冬30克 阿胶10克 五味子6克 玄参18克 钩藤10克 甘草12克

服二剂而身麻愈，服六剂而肿胀消，服至十二剂则抽搐大减，夜能安睡。改用白薇汤：

当归30克 白薇15克 党参6克 炙甘草6克

服三剂，抽搐基本得到控制。后因与人争诟气恼而病又复，但其势不及原来。先以化肝煎以解气郁，继以大定风珠滋阴息风而愈。

12.“甘温除大热”及东垣方的临床运用

“温能除大热”或称“甘温除大热”，是中医学中经常被引用的一句术语。就其本身的学术意义来说，它与“滋阴降火”、“引火归元”等法是不同的。换句话说，“温能除大热”中的“大热”，是不能用“壮水之主”或“益火之源”的方法来解决的，必须用甘温的药物，补益脾胃元气，才能收到治疗效果。“温能除大热”的治疗方法，别具一格，有一定的理论基础及其临床实践意义。

（1）“温能除大热”的来源

“温能除大热”这一提法，首先见于李东垣所著的《脾胃论》。他说：“内伤脾胃乃伤其气，外感风寒乃伤其形。伤其外者为有余，有余者泻之；伤其内者为不足，不足者补之。内伤不足之病，苟误认作外感有余之病而反泻之，则虚其虚也。实实虚虚，如此死者，医杀之耳。然则奈何？唯当以辛甘温之剂，补其中而升其阳，甘寒以泻其火则愈矣。经曰：劳者温之，损者温之。又云：温能除大热，大忌苦寒之药，损其脾胃……”

如上所论，“温能除大热”原为《内经》之文，似乎无可疑议。但王履的《医经溯洄集》中载有“内伤余议”一文，对“温能除大热”出于《内经》的说法发生了怀疑。他说：“今东垣乃以‘温’为温凉之‘温’，谓宜温药以补元气而泻火邪；又易‘损者益之’为‘损者温之’；又以‘温能除大热’为《内经》所云，而遍考《内经》，并无此语，此亦不能无疑者也。”根据王履的说法，在《内经》中是找不到“温能除大热”的依据。但是，“温能除大热”这一学术主张，由于东垣的发扬与实践，逐渐被广大医家所采用，直至今日，在中医学的理论与临床上仍然发生着深刻的影响，这是不能忽视的。

（2）内伤大热的病理机制

“温能除大热”既然作为内伤发热的治疗法则，那么，了解内伤大热

的病理机制是有必要的，同时，这对研究李东垣的内伤学说，也是一个关键性的问题。

《脾胃论》说：“若饮食失节，寒温不适，则脾胃乃伤；喜怒忧恐，损耗元气。既脾胃气衰，元气不足，而心火独盛。心火者，阴火也，起于下焦，其系系于心。心不主令，相火代之。相火下焦包络之火，元气之贼也。火与元气不两立，一胜则一负。脾胃气虚，则流于肾，阴火得乘土位。故脾证始得，则气高而喘，身热而烦，其脉洪大……或渴不止。”东垣在此指出了饮食失节，或喜怒忧恐，则内伤脾胃元气，正如《难经》所说：“饮食劳倦则伤脾”。《素问·痹论》也说：“饮食自倍，肠胃乃伤。”《素问·调经论》又指出：“其生于阴者，得之饮食居处，阴阳喜怒。”可见东垣内伤脾胃的学说是本于《内经》及《难经》，总结了前人的理论思想，并且还有一定的发展。

脾胃位居中焦，司仓廩之职，为后天之本，营卫气血生化之源，具有升清降浊，斡旋阴阳的作用。《素问·五常政大论》说：“阴精所奉其人寿，阳精所降其人夭”。阴精所奉，指脾胃调和，谷气上升，行春夏之令，得阳气长养，故健康而多寿；阳精所降，指脾胃失和，谷气下流，反行秋冬之令，故体衰而易夭。因此，内伤脾胃，元气不足，则使清阳不能上升而反下降；清阳下流则成湿浊，湿浊下行，少阴被郁，阴不制火则阴火乃动。水中之火名阴火，沿少阴经脉上冲于心；心为君主之官，不主令也不受邪，有邪则心包相火代之。《灵枢·邪客》说：“心者，五脏六腑之大主也……邪弗能容也，容之则心伤，心伤则神去，神去则死矣。故诸邪之在于心者，皆在于心之包络。”如此，包络代心君受阴火之袭，则心主火旺，所以出现脉洪大，烦渴，身热等症状。

“阴火上乘土位”是对内伤脾胃病理机制的高度概括。所谓“土位”，指水谷清阳之气上布胸中心肺的生理模式。《灵枢·决气》指出：“上焦开发，宣五谷味，熏肤，充身，泽毛，若雾露之溉，是谓气。”说明了谷气入脾胃后，必须上奉心肺，借心肺之开发而化生为元气。如果脾胃之气下流，不能上奉心肺，则下焦阴火取而代之，心胸乃热，发为内伤的病变。

《素问·经脉别论》又说：“食气入胃，浊气归心，淫精于脉。脉气流行，经气归于肺。肺朝百脉，输精于皮毛……”说明了古人确实认识到了水谷精气由心而入脉，由脉而上归于肺，在肺中进行气体交换，然后才能发生水谷的滋养功能。如果脾胃一有损伤，导致清阳（谷气）不能上升，而使上焦不行，下脘不通，就会产生内伤发热证候。如《素问·调经论》说：“有所劳倦，形气衰少，谷气不盛，上焦不行，下脘不通，胃气热，热气熏胸中故内热。”而李东垣在《脾胃论》中则将其概

括为“脾胃既虚，不能升浮，为阴火伤其升发之气”。

所以，阴火的产生是和清阳下陷分不开的，正因为清阳下陷，才导致了阴火上乘土位。所以说：“火与元气不两立，一胜则一负”。治疗时就不能单纯以水制火，也不能单纯以寒伏火，只有用甘温保元之剂，采用以补为泻，以升为降的方法，才能使阴火下降而元气复位。

（3）阴火与阴虚火亢的鉴别

李东垣所说的阴火上冲，和朱丹溪所说的阴虚火亢，两者发病性质不同，治疗也有差别。

东垣的阴火上冲，是由于脾气下流，由脾及肾，病之本在脾，病之标在肾。所以在治疗上先补脾。如果忽视脾在发病中的主要地位，反以标为本，当然不符合东垣的精神。因此，脾湿郁遏下焦，虽能激发阴火上冲，但同燥热伤阴，房劳耗精，肾水亏损所发生的各种火热之证是有所不同的。如果“阴火上冲”兼见肾水不滋时，东垣在温补方中也少加生地、黄柏以泻阴火而滋其水。同时，东垣对于湿热伤阴也有充分的认识。他曾说：“脾胃虚，则湿之气流于脐下，肾与膀胱受邪……二者俱弱，润泽之气不行……津液不濡……口燥咽干而皮毛不泽也。”在治疗时，为了解救肾水之困，必须补脾升阳，使湿邪不下溜，则阴火自解，大热可去。此证若专事滋补，不从脾胃入手，必然助湿腻脾，反而激发阴火上冲。

而朱丹溪所说的阴虚火亢，是肾本身的水火不相协调的问题，阴虚则火亢，这并非实火内盛，而是由于阴水不足所致，在治疗上可以采用滋阴壮水的方法。张景岳曾说：“盖火性本热，使火中无水，其热必极，热极则亡阴，而万物焦枯矣。”人或欲念过极，房室耗伤，必动相火，耗散其水；或在汗、下之后，失血之余，均能导致水虚不能制火的证候。如心烦少寐，头晕，口干咳嗽，盗汗，夜热及失精等。因此，治疗上“只补水以配火，壮水之主以制阳光”。临床常用六味地黄汤、一阴煎，兼服归脾丸，疗效比较好。至于苦寒损阳之剂，慎不可轻投。例如，曾治一患者，素有便血，经常头目眩晕，面赤，耳鸣，时觉一团火气上冲，午后更觉显著。一日大便后，突然头晕仆地。醒后神志恍惚如在梦中，环顾其子女，不能一一呼其名。舌质红绛而干，无苔，脉大，尺部更显。此病阴亏阳亢，已非一日，水不制火，不能涵木，所以头目眩晕。神明失于主宰，故神志不慧，情境俱忘。法当补水配火，以制阳

光。用大剂六味地黄汤，加玳瑁、阿胶、生龙骨、生牡蛎、麦冬、人参、五味子。文火慢煎取浓汁，时时呷服。三剂后，头晕与烦热显著减轻，但精神仍恍惚不定，记忆时好时差，转用“专翕大生膏”与归脾丸两方，培正固本补其精神，交替服用，三个月后诸症皆去。

（4）阴火与虚阳外越的鉴别

东垣所指的“阴火”发热，与“虚阳外越”的发热有本质的区别。从对阴火证的描述来看，“作蒸蒸而躁热，上彻头项，傍彻皮毛，浑身躁热作，须待袒衣裸居，近寒凉处即已，或热极汗出亦解”，显然不是虚阳浮越于外的发热。阳越发热，只恐一身汗出，阳气外亡，其命随之而灭，焉有“热极汗出亦解”之理。

虚阳外越的发热是以阴寒内盛，阳气衰弱作为病理基础。如《伤寒论》说：“少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，身反不恶寒，其人面色赤……”这里所讲的“里寒外热”，即是阴盛迫阳，虚阳外越所致的发热，这是人体真火外露的表现。这种真火，平时潜藏在肾水之中，藏则能生气，露则为病。水中之火，又称龙火，龙火不能潜藏，源于火气极虚，水寒盛极，逼迫其火外越。如赵养葵所说：“平日不能节欲，以致命门火衰，肾中阴盛，龙火无藏身之位，故游于上而不归……”龙火不藏，虚阳外越的常见证候有：上身大热，下身冰冷，人事昏沉；或咽喉肿痛，咳嗽喘促；或自汗，心烦，大便欲出，小便不禁；或面赤如朱，不思茶水，而胸腹痛甚欲按；或口舌生疮，牙缝流血；或吐血而心烦不安；或消渴而饮一溲二……阴盛逼阳的脉象多见洪大无伦，或两尺虚软，或见细数，但都以按之无力为特点。

阳越发热，轻者以辛热药杂于壮水剂中，导之下行，如右归饮、八味地黄汤之类；重者则不掺阴柔之品，采用“四逆汤类”方剂急救亡失之阳。虚阳上窜，吐血特别严重的，用镇阴煎加童便，效果很理想；痰涎涌逆，喘鸣气急，上实下虚者，用独参汤调服黑锡丹有奇效。经治疗后，阳气恢复，龙火潜藏，仍继续服用甘温之药，以促进生化之源，并须节制房事，养心宁神。曾治：吴某，男，48岁。一日突然吐血，逐渐增多，心内发热，躁烦异常。曾服百合固金汤与荷叶丸，病证反而加剧。脉洪大而软，沉取无力，舌胖大质嫩，苔白滑。但头上汗出，咽干而痛，不欲饮水。此阴盛逼阳，龙火浮越之重证，急服镇阴煎，加童便一碗为引。一剂尽，血止神安。改服桂附地黄汤合生脉饮，又二剂，诸症向愈。但觉体乏无力，动则心悸气短，乃以归脾汤送服金匱肾气丸，

大约月余而康。

（5）“温能除大热”的治疗范畴及代表方

“温能除大热”的“大热”指的是内伤大热，不是外感的发热。内伤与外感，均有发热的证候，但在辨证上各有其不同的特点，不得混淆。东垣《内外伤辨惑论》，正确地指出了内伤与外感发热的不同，使人有所鉴别，这无疑是一个很大的贡献。兹录其文如下：

“外伤寒邪，发热恶寒，寒热并作，其热也翕翕发热，又谓之拂拂发热，发于皮毛之上，如羽毛之拂，明其热在表也……其面赤，鼻气壅塞不通，心中烦闷，稍似袒裸，露其皮肤，已不能禁其寒矣……其内伤饮食不节，或劳役所伤，亦有头痛，项强，腰痛，与太阳表证微有相似，余皆不同……是热也，非表伤寒邪发热也，乃肾间受脾胃下流之湿气，闭塞其下，致阴火上冲，作蒸蒸而躁热……须袒衣裸居，近寒凉处即已，或热极而汗出亦解”。

基于以上的辨证，可见外感发热是寒热并作，热在皮肤之浅，且有恶寒鼻塞等；内伤发热，寒热不是并见，其热为燥热，有时发作，乃下焦阴火上冲，必近寒凉，或热极汗出，方得减退。

此外，外感的发热是手背热而手心不热，内伤的发热是手心热而手背不热。而且外感脉象是人迎大于寸口，内伤脉象是寸口大于人迎。

补中益气汤是“温能除大热”的代表方剂。方中以黄芪、人参、炙甘草（名保元汤）作为全方的主体，取其性味甘温，大补脾胃元气，使脾胃元气充足而恢复其升清降浊的作用，是“甘温除大热”的基本治疗方针。白术健脾而除湿，当归补血而润燥，升麻、柴胡鼓动清阳以上升，陈皮理气化浊以下降。服药后，脾胃元气上升以奉心肺，而使营卫通达，气血调顺；阴火无援则不能上乘，包络大热可以不清而自消。

（6）东垣方的临床运用

1) 补中益气汤

病案一：内伤发热

平某，男，37岁。素体虚弱，肝胃不和。十月中旬某日，突然发生吐血，咳嗽。伴见午后发热，饮食衰减，周身倦怠无力，二便尚调，其脉虚数，舌质淡，苔薄白。初用“加味救肺汤”，服二剂后咯血虽止，转增腹痛，泄泻，烦悸，脘闷，不欲食，午后发热达39℃，脉仍虚数。辨为虚劳腹痛，用小建中汤建中气，缓里急，服药后腹痛果愈。但仍发热不退，周身无力，头晕少气，不思饮食，腹泻不止，脉象同前。此“阴火上乘土位”，清浊失调之变，乃用东垣补中益气汤，另加生甘草6克以泻心包之热。服一剂即觉减轻，略事加减，三剂后体温正常，腹泻止，食欲逐渐增加。改用归脾汤进退而愈。

病案二：内伤发热

李某，女，35岁。得病已数月，心烦口干，气弱食衰，周身发热如同火灼，必须将后背贴靠家中方石筑砌之墙方觉凉爽。月经每来必多，下肢浮肿，动作乏力。大便时有溏泻，小便微黄，脉大而无力的，舌质淡苔薄白。曾服滋阴凉血之方，非但无效，反增胸闷而纳呆不食。当从内伤脾胃，清阳下陷，阴火乘于心胸辨治。

黄芪9克 人参6克 生、炙甘草各6克 当归6克 陈皮3克 柴胡3克 升麻3克 葛根3克 生姜3克 大枣3枚

服三剂，心烦，口干等已去，燥热有所改善。上方加知母、黄柏各3克，连服六剂而热退。改服参苓白术散巩固。

病案三：习惯性流产

酒某，女，32岁。每次怀孕至三个月左右，即自行流产，已连续发生三次。现又怀孕已三月，胎漏见红，腹内下坠，腰酸，白带极多，食少体倦。舌淡苔白，脉滑无力。此脾虚湿盛，清阳不升，中气不足则胎元不固；湿渗于下则带下淋漓。治疗必须补脾升清，去湿固本，胎气方能安和。

黄芪12克 党参12克 白术30克 当归9克 炙甘草9克 柴胡3克 升麻3克 杜仲9克 续断9克 陈皮3克

服三剂，带下已止，腹坠腰酸明显减轻，但漏红未止。转用胶艾四物汤加炙甘草10克，服三剂后，血止胎安。

病案四：腹泻脱肛

郎某，男，56岁。患大便溏泄，每日三四次，伴发脱肛。饮食减少，体疲无力，屡治无效。面黄舌淡，脉缓软无力，一派脾虚之象昭然若揭。

黄芪12克 人参9克 白术9克 土炒当归6克 炙甘草 9克 柴胡3克 升麻3

克 生姜3克 大枣3枚鳖头1个（荷叶包，煨透）

服六剂，腹泻与脱肛不发，又将方中人参改为党参12克，续服六剂而愈。

2) 调中益气汤

病案五：会阴下坠

郝某，男，38岁。自诉前后阴之间（即会阴部）下坠已数年，抽掣酸胀，如有物嵌顿其中，似欲大便而不能，胀塞极苦，久立则更甚，小便不利。脉软，按之无力，舌苔白滑而腻。此脾虚而清阳下陷，湿气下流，结于会阴，升降不能，所以重着难拔。治当补脾运湿，升阳举陷。

黄芪12克 党参12克 苍术9克 白术9克 黄连3克 黄柏3克 柴胡3克 升麻3克 陈皮3克 葛根3克 姜枣为引

此方化裁进退，约服三十剂而愈。

【解说】

调中益气汤由保元汤加升麻、柴胡、苍术、陈皮、黄柏而组成。本方与补中益气汤均治内伤脾胃，但本方重在清浊相干而兼湿热。所以脉虽大但无力，沉取反涩，证以二便不调，泄泻脓血为主。本案清气下陷，湿凝会阴，而见小便不利，更见舌苔白腻，湿盛久必蕴热，故服调中益气汤而效。

3) 升阳益胃汤

病案六：带下淋漓

魏某，女，28岁。小产之后，续发带下淋漓，色白清稀，甚则小腹下坠。因带下太多，致使妇科无法外查。舌淡苔白，脉弦缓无力。证属脾气虚衰，清阳下陷，湿气不运，注入冲任，化而为带下。

黄芪12克 党参12克 白术30克 炙甘草6克 柴胡3克 升麻 3克 防风3克 羌活3克 独活3克 黄连3克 半夏10克 茯苓10克 泽泻10克 陈皮6克 白芍6克

服六剂，带下减轻三分之二，体力有所增加。又服六剂而带净。

病案七：皮肤皴裂

李某，女，43岁。两手掌大小鱼际部位，胸部及股腿等处皮肤皴裂，纵横交错，干燥疼痛而痒。饮食无味，体疲肢倦，两臂疼痛，面色萎黄不泽，月经一月再行。舌质淡，脉软无力。证属脾元不足，不能上奉心肺，阴火复乘其位，气血不布，不能熏肤、充身、泽毛，故有此

变。

党参10克 白术6克 生、炙甘草各6克 黄柏4.5克 防风4.5克 羌活4.5克 独活4.5克 葛根6克 白芍6克 柴胡3克 升麻3克 生地3克

并以猪油二两，杏仁一两捣成泥，将油熬化，倒入杏泥，调匀成膏，外用擦手。

服药四剂，外用一剂而愈。

【解说】

饮食劳倦，内伤脾胃，元气不足，清阳下陷后，不但引发下焦阴火上冲，还可发生脾湿下流，蕴郁下焦的各种病变。所以，在内伤分类上，有湿多热少，热多湿少及湿热参半的三种不同情况。针对这三种差别，东垣设升阳益胃汤、补脾胃泻阴火升阳汤和调中益气汤分别治之。升阳益胃汤由六君子汤加黄芪、黄连、柴胡、防风、羌活、独活、白芍、泽泻组成，凡内伤气虚，湿多热少，清气不得上升者宜服此方。

4) 寒胀中满分消汤

病案八：中满腹胀

徐某，女，24岁。患大便溏泻已二年多，每日三四次。逐渐发展为中满腹胀，从心下至少腹胀闷不堪，尤其以进食后为甚。饮食乏味，带下多，手心灼热。西医诊断为“肠系膜淋巴结核”，按结核治疗无效。其人舌质淡嫩，苔薄白，脉沉弱无力。此证属脾虚有寒，中气不运，清阳下陷，浊阴在上；又带下多而手心热，正是东垣所谓内伤之热。

黄芪10克 党参10克 当归10克 茯苓10克 厚朴10克 半夏10克 猪苓10克 泽泻10克 黄连6克 吴茱萸6克 生姜6克 草薢仁6克 萆薢6克 益智仁6克 干姜3克 川乌3克 黄柏3克 麻黄3克 柴胡3克 升麻3克

服五剂而效，腹胀减轻；再服五剂，大便成形而欲食；又服五剂，带下止，腹胀消而手心不热。

【解说】

中满腹胀，有寒热之分。饮食劳倦，损伤脾胃，不能运化精微，水谷聚而不散，便成胀满。《素问·至真要大论》虽然有“诸胀腹大，皆属于热”之说，但东垣认为，从临床所见，“大抵寒胀多而热胀少，治之者宜详辨之”。并且提出：“中满治法，当开鬼门，洁净府。开鬼门，谓发汗也；洁净府者，利小便也。中满者，泻之于内，谓脾胃有病，当令上下分消其湿。下焦如渎，气血自然分化，不待泄滓移；或如大实大满，大小便不利，从权以寒热药下之。”（《兰室秘藏·中满腹胀门》），这

就是东垣寒胀中满分消汤的治疗作用。

5) 益气聪明汤

病案九：耳鸣耳聋

葛某，男，30岁。右耳鸣响，以夜深人静或晨起时最为明显，而且耳聋不聪。体疲无力，大便不畅，小便频短。舌质嫩，脉沉弦无力。曾服滋阴潜阳，平肝息风方药数十剂而不效。此脾气虚而清阳不升，下焦阴火上犯清窍。东垣之法，于升中求降，补益脾胃元气则阴火自能复其位。

黄芪12克 党参12克 白芍12克 炙甘草10克 葛根6克 蔓荆子6克 柴胡3克 升麻3克 黄柏3克

服四剂则效，又服六剂耳鸣止，而听力恢复正常。

病案十：目障不明

李某，男，48岁。患左眼中心性视网膜炎，视物不清，眼前有黑影如棱形，甚则遮覆视野。目涩无泪，神光不见，视力下降至0.4。舌质淡嫩，脉虚大。此清阳不能上奉，精血又亏于下。

黄芪12克 党参12克 白芍12克 炙甘草10克 升麻3克 防风3克 葛根3克 黄柏3克 藁本3克 石斛12克 菟丝子12克

服七剂后，目中不觉干涩，眼前黑影变小。上方减去防风、藁本，加黄芪至18克，杞子10克。又服三剂后，查视力上升为0.9。转用补益肝肾，以杞菊地黄汤加当归、白芍、覆盆子、酸枣仁，又服十剂，视力上升为1.2。眼底镜检查：视网膜水肿及炎症皆消。

【解说】

《灵枢·邪气脏腑病形》说：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍，其精阳气上走于目而为睛，其别气走于耳而为听。”《灵枢·大惑论》又说：“目者，五脏六腑之精也，营卫魂魄之所常营也，神气之所生也。”所以，头目清窍灵愚与否与脾胃气的盛衰有密切关系。若因饥饱劳行损伤脾胃，生发之气既弱，其营运之气不能升，且五脏六腑之精无所禀受而不能上注，邪塞空窍，耳目等清灵之官失其聪明。因此，治宜补益脾胃之气，使精阳气上走清窍则能耳聪目明。

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编
■ 刘渡舟 程昭寰 编著

第十辑

现代著名老中医名著重刊丛书

刘渡舟医书七种

肝病

证治概要



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·第十辑
刘渡舟医书七种

刘渡舟名家研究室 王庆国 刘燕华 主编



肝病 证治概要

编著 刘渡舟 程昭寰

人民卫生出版社

版权页

图书在版编目（**CIP**）数据

肝病证治概要/刘渡舟，程昭寰编著.—北京：人民卫生出版社，
2013

（现代著名老中医名著重刊丛书.第10辑，刘渡舟医书七种）

ISBN 978-7-117-17358-2

I.①肝... II.①刘...②程... III.①肝病（中医）-中医治疗法
IV.①R256.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第120982号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购
书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

现代著名老中医名著重刊丛书（第十辑）

刘渡舟医书七种

肝病证治概要

丛书主编：王庆国 刘燕华

编 著：刘渡舟 程昭寰

出版发行：人民卫生出版社有限公司

人民卫生电子音像出版社有限公司

地 址：北京市朝阳区潘家园南里19号

邮 编：100021

E - mail: ipmph@pmph.com

制作单位：人民卫生电子音像出版社有限公司

排 版：人民卫生电子音像出版社有限公司

制作时间：2018年2月

版 本 号：V1.0

格 式：mobi

标准书号：ISBN 978-7-117-17358-2

策划编辑：李丽

责任编辑：李丽

打击盗版举报电话：**010-59787491** E-mail: **WQ@pmph.com**

注：本电子书不包含增值服务内容，如需阅览，可购买正版纸质图书。

刘渡舟医书七种编写委员会

主 编 王庆国 刘燕华

副主编 李宇航 梁永宣

编 委（以姓氏笔画为序）

于博睿 马小娜 马春雷 王 冬 王庆国

王国华 王利敏 王雪茜 刘 敏 刘丹彤

刘晓倩 刘晓辉 刘燕华 闫军堂 许仲宁

孙 燕 孙良明 孙晓东 李 欣 李成卫

李宇航 李丽娜 李晓莉 李鹏英 吴范武

张 欢 张 娜 张雪亮 陈 明 陈 萌

畅洪昇 周 刚 郑丰杰 房克英 屈会化

赵 妍 赵 琰 赵伟鹏 赵宇明 钟相根

贾春华 倪 磊 高 飞 郭书文 梁永宣

程发峰 傅延龄 鲁 艺 赛佳洋

学术秘书 闫军堂

出版说明

自20世纪60年代开始，我社先后组织出版了一些著名老中医经验整理著作，包括医案、医论、医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国现代中医学术的发展发挥了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显。这些著名老中医在我国近现代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。他们的著作多成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前。无论是亲自撰述，还是口传身授，或是由其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华。诸位名老中医不吝秘术，广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，今已很难见到，部分著作甚至已成为中医读者的收藏珍品。为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将部分具有较大影响力的名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》并分辑出版，以飨读者。

第一辑 收录13种名著

- | | |
|-------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |
| 《钱伯煊妇科医案》 | 《朱小南妇科经验选》 |

《赵心波儿科临床经验选编》 《赵锡武医疗经验》
《朱仁康临床经验集——皮肤外科》
《张赞臣临床经验选编》

第二辑 收录**14**种名著

《中医入门》 《章太炎医论》
《冉雪峰医案》 《菊人医话》
《赵炳南临床经验集》 《刘奉五妇科经验》
《关幼波临床经验选》 《女科证治》
《从病例谈辨证论治》 《读古医书随笔》
《金寿山医论选集》 《刘寿山正骨经验》
《韦文贵眼科临床经验选》 《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑 收录**20**种名著

《内经类证》 《金子久专辑》
《清代名医医案精华》 《陈良夫专辑》
《清代名医医话精华》 《杨志一医论医案集》
《中医对几种急性传染病的辨证论治》
《赵绍琴临证400法》 《潘澄濂医论集》
《叶熙春专辑》 《范文甫专辑》
《临诊一得录》 《妇科知要》
《中医儿科临床浅解》 《伤寒挈要》
《金匱要略简释》 《金匱要略浅述》
《温病纵横》 《临证会要》
《针灸临床经验辑要》

第四辑 收录**6**种名著

《辨证论治研究七讲》 《中医学基本理论通俗讲话》
《黄帝内经素问运气七篇讲解》 《温病条辨讲解》
《医学三字经浅说》 《医学承启集》

第五辑 收录**19**种名著

《现代医案选》 《泊庐医案》
《上海名医医案选粹》 《治验回忆录》
《内科纲要》 《六因条辨》
《马培之外科医案》 《中医外科证治经验》
《金厚如儿科临床经验集》 《小儿诊法要义》
《妇科心得》 《妇科经验良方》
《沈绍九医话》 《著园医话》
《医学特见记》 《验方类编》
《应用验方》 《中国针灸学》
《金针秘传》

第六辑 收录**11**种名著

《温病浅谈》 《杂病原旨》
《孟河马培之医案论精要》 《东垣学说论文集》
《中医临床常用对药配伍》 《潜厂医话》
《中医膏方经验选》 《医中百误歌浅说》
《中药炮制品古今演变评述》 《赵文魁医案选》
《诸病源候论养生方导引法研究》

第七辑 收录15种名著

《伤寒论今释》	《伤寒论类方汇参》
《金匱要略今释》	《杂病论方证捷咏》
《金匱篇解》	《中医实践经验录》
《罗元愷论医集》	《中药的配伍运用》
《中药临床生用与制用》	《针灸歌赋选解》
《清代宫廷医话》	《清宫代茶饮精华》
《常见病验方选编》	《中医验方汇编第一辑》
《新编经验方》	

第八辑 收录11种名著

《龚志贤临床经验集》	《读书教学与临症》
《陆银华治伤经验》	《常见眼病针刺疗法》
《经外奇穴纂要》	《风火痰瘀论》
《现代针灸医案选》	《小儿推拿学概要》
《正骨经验汇萃》	《儿科针灸疗法》
《伤寒论针灸配穴选注》	

第九辑 收录11种名著

《书种室歌诀二种》	《女科方萃》
《干祖望医话》	《名老中医带教录》
《班秀文妇科医论医案选》	《疑难病证治》
《清宫外治医方精华》	《清宫药引精华》
《祝谌予经验集》	《疑难病证思辨录》

《细辛与临床》（附 疑难重奇案七十三例）

第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）

《伤寒论十四讲》 《伤寒论通俗讲话》

《伤寒论诠解》 《新编伤寒论类方》

《经方临证指南》 《金匱要略诠解》

《肝病证治概要》

这些名著大多于20世纪60年代前后至90年代后在我社出版，自发行以来一直受到广大读者的欢迎，其中多数品种的发行量达到数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床诊疗水平和促进中医事业发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时尽可能保持原书原貌，只对原著中有欠允当之处及疏漏等进行必要的修改。为不影响原书内容的准确性，避免因换算等造成的人为错误，对部分以往的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的临床检测项目与方法等，均未改动，保留了原貌。对于原著中犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社
2013年3月

整理说明

刘渡舟是北京中医药大学已故终身教授、《伤寒论》专业首批博士生导师，当代著名的中医学大家、中医教育家。刘老行医、执教半个多世纪，上溯岐黄之道，下逮诸家之说，力倡仲景之学，博采众长，学验宏富，形成了鲜明的学术思想和医疗风格，被誉为“伤寒泰斗”、“经方大家”，日本汉方界更称其为“中国治伤寒第一人”，其学术成就为中医同仁所公认，在中医学界享有盛誉。刘老以振兴中医、培育桃李为己任，在繁忙的医疗、教学、科研之余，坚持著书立说，笔耕不辍，培养后学。刘老一生著述颇丰，曾出版中医学术著作20多部，发表学术论文100余篇，为传承中医药事业作出了杰出贡献。

20世纪80年代，刘老的学术经验日臻成熟与完善，在当时十多年的时间里，他出版了数十部关于《伤寒论》、《金匱要略》及经方运用的研究专著，具有很高的学术水平和临床应用价值，深受广大读者欢迎，在中医学界产生了很大的影响，对于推动仲景学术发展和提高中医临床水平起到了重要的作用。为了系统总结刘老的学术思想和医疗经验，并从中窥探其治学方法与道路，我们精选了最能反映刘老治伤寒、用经方、精临证的学术著作，经撰次整理，辑而成帙，名为《刘渡舟医书七种》，付梓再版，以飨读者。这7本代表性医书分别是《伤寒论十四讲》、《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论诠解》、《新编伤寒论类方》、《经方临证指南》、《金匱要略诠解》、《肝病证治概要》。这些著作能突出反映刘老之方证相对论、辨证知机论、古今接轨论、气机论、攻邪论、水火论、湿证论、脾胃论、肝胆论以及抓主证等学术思想及其对经方的运用经验，汇集了刘老行医50余年的学术经验和心血结晶，贯彻了理论和实践相结合的方针。通过阅读刘老文稿，读者可窥其学术思想和临床经验之一斑，并有助于系统地掌握刘老的临证特色和诊治经验。编撰者也希望通过这些文字笔墨展示经方大家刘渡舟教授的学术经历及成就，使一代名家为中医药事业不屈不挠的奋斗精神、人格品质及宝贵经验得以传世后人，为中国医学史树起一座不朽的丰碑。

为了使读者能原汁原味地阅读刘老著作，本次修订再版《刘渡舟医

书七种》时，采取尽可能保持原书原貌的原则，除对原著中出现的文字、标点错误稍加更正，并在不影响文意的前提下润色语句不通顺之处外，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排，从而规范了原书的体例层次。而对原书中出现的古今字、异体字、繁简字以及以往的病名、药名、计量单位等，均未改动，保留了原貌。

2007年，为了整理、挖掘、继承和抢救京城名老中医的学术经验，北京市中医管理局启动了“名老中医药专家学术思想抢救挖掘与优秀传承人才培养联动工程”（简称“薪火传承3+3工程”），目的在于做好首都名老中医学术思想的抢救、整理和挖掘工作。刘渡舟名家研究室

（No.2007-SZ-A-09）于2007年10月首批获北京市中医管理局批准，2008年1月授牌，2008年6月正式启动建设，进行了大量卓有成效的工作。将刘老积累多年的学术著作、文章、讲稿等整理、汇编、出版更是研究室的重要工作之一，本书即是在研究室全体成员的共同努力之下完成的，在此，谨向名家研究室这一名老中医学术经验平台的发起者——北京市中医管理局致以崇高的敬意。同时，也向所有参与此次编撰工作的各位同仁致以谢意。

刘渡舟名家研究室主任
北京中医药大学副校长，教授、博士生导师
王庆国
2012年12月

前言

我们写的这本小册子叫《肝病证治概要》，是专门论述治疗肝病问题的。肝病在临床中比其他四脏病都多，其证候表现极为复杂，如果不掌握它的生理、病理及其治疗规律，则很难取得疗效。

历代医家对肝病的研究是比较重视的，其中最杰出的当推清代王旭高的《西溪书屋夜话录》，因为他采撷了诸家之长，并参以己意，推陈出新地写出了“治肝三十法”，为肝病的专科治疗树立了楷模。

目前，肝病仍是一个重要课题，其中尤以传染性肝炎流行最为广泛，威胁着群众的身体健康。为此，我们搜集古人治肝病的经验，结合临床的要求，以及我们的治疗体会，写出了《肝病证治概要》一书，作为治疗肝病的参考，聊尽我们的绵薄之力。

全书共分上、中、下三篇，上篇论述了肝病的生理、病理、诊断、治疗等问题；中篇论述了肝病的分类，肝病的辨证和临床的经验；下篇附《西溪书屋夜话录》评讲一文，以作为学习王氏治肝方法的参考。且论及胆腑理论和临床用药等相关问题，前后互阅，可相得益彰。本书力求理论与实践相结合，以能解决临床实际问题为宗旨。由于我们的知识有限，其中难免有错误之处，希望读者不吝教言，批评指正为幸。

编者识
1984年10月

Table of Contents

[上篇 概论](#)

- [一、肝在生命运动中的地位和生理特点](#)
- [二、肝病的病变规律](#)
- [三、肝病的诊断学特点](#)
- [四、肝病的治疗原则](#)

[中篇 肝病证治规律](#)

- [第一章 肝气郁结证治](#)
- [第二章 肝气冲逆证治](#)
- [第三章 肝火证治](#)
- [第四章 肝火伤阴证治](#)
- [第五章 肝风证治](#)
- [第六章 湿热诸毒黄疸证治](#)
- [第七章 气血瘀滞证治](#)
- [第八章 寒热错杂证治](#)
- [第九章 肝寒证治](#)
- [第十章 肝虚证治](#)

[下篇 附篇](#)

- [一、《西溪书屋夜话录》评讲](#)
- [二、胆腑理论及临床](#)
- [三、肝病用药指归](#)

[返回总目录](#)

上篇 概论

肝胆理论是藏象学说的重要组成部分，是研究肝胆的生理、病理、诊断与治疗的一门科学。中医对肝胆的认识，早在《内经》中就有比较系统的论述，以后的《千金方》、《中藏经》等著作又作了进一步的发挥。到了金元时代，朱丹溪提出“主疏泄者肝也”，把肝脏看做是机体运行气血和新陈代谢的重要藏器，对肝的生理有了新的见解。明清以后，随着温病学的崛起，对肝的认识又深化了一步，尤其是叶天士养胃阴学说建立以后，并经过魏玉璜、王旭高等人的共同努力，划清了肝阴、肝阳、肝气、肝血的发病范围和疏肝、养肝的治疗界限，从而大大丰富了肝病的辨证论治理论，使临床医生对肝脏的生理、病理、发病阶段和临床特点，以及辨证论治等，有一定的规律可循，成为指导临床实践的主要依据。

一、肝在生命运动中的地位和生理特点

藏象学说是以五脏为中心，把脏腑与脏腑，脏腑与形体各器官组织，脏腑与外界环境联系为一个有机的统一整体的学说。五脏即是生命运动的重要物质——精、神、气、血的藏舍之地，也是生命运动的根本。如《灵枢·本脏》云：“五脏者，所以藏精神血气魂魄者也。”《灵枢·本神》亦云：“五脏主藏精者也，不可伤。”《本脏》篇还进一步指出：“五脏者，所以参天地，副阴阳而连四时，化五节者也。”因此，早在《内经》中就已把五脏看做是整个生命现象和生理活动的中心了。

心、肝、脾、肺、肾五脏，虽各有不同的生理功能，但它们之间，既分工又合作，互相依赖，互相联系，构成一个有机整体，从而保证了

机体正常的生命活动。肝在生命运动中的作用又如何呢？肝属足厥阴经，是一个多叶的脏器，足厥阴经脉循行分布最广，上至巅顶，下至足底，与胆、胃相连，与冲、任、督诸经脉相通；联系目、喉、舌、唇、胁、少腹、前阴、睾丸等部位；居于季胁，排列六经之末，位处水火之间，应春气而主生、升，这就充分说明了肝在人体生命活动中的重要作用。

肝为厥阴，中见少阳之化。“少阳”是指初生之阳，主持生发之气。因肝应春生气，而配在东方，“肝者，东方木也，木者春也……万物始生。”（《难经》）虽然这是取类比象的说法，但在一定程度上反映了肝的基本特性。另外，肝属厥阴，《素问·至真要大论》云：“两阴交尽，谓之厥阴”。所谓交尽，意即阴之极尽的意思，阴之尽则阳之始，故又有一阳之气来复之机。因为厥阴与少阳相为表里，故《灵枢》云：“肝为阴中之少阳”。为此，肝有阴阳体用之异。

“体柔用刚”，是肝的另一生理特性。因为肝主藏血，肝赖血养，故云体柔，然肝气主疏泄，气为阳，故云用刚。且肝与胆为表里，内寄相火，是以肝体虽柔而其用则刚。肝之体柔用刚的特性，决定了肝的阴阳对立统一的关系，也只有在刚柔相济、血养其体、气资其用的前提下，肝才能调畅敷和而不病。

由于肝的生理特性不同于其他四脏，所以它在人体生命运动中也有其独自的特点。例如：

1.肝主生发

生发，是指生长和升发。自然界万物的生、长、壮、老、已的变化规律，都是先从春天生发之气开始的，《素问·四气调神大论》说：“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣”。因为春天的阳气上升，促进了万物的欣欣向荣，人之于气交之中，也必须顺应这个规律，所以肝应春生之气，而主升发的作用，它是人的生命源泉和动力，林佩琴说：“凡上升之气，皆从肝出”。（《类证治裁》）升降出入的运动规律，推动了脏腑气化，脏腑气化活动，维持了升降出入的平衡协调，而整个脏腑气化活动则都藉肝胆生发之气的鼓舞。沈金鳌说：“肝和则气生，发育万物，为诸腑生化”。（《杂病源流犀烛》）张石顽也说：“肝脏生发之气，生气旺则五脏环周，生气阻则五脏留著。”（《张氏医通》）由此可见，肝主生发之气是肝的重要生理功能。

2.肝主疏泄

疏泄，意即肝有疏通排泄的作用。肝主疏泄主要表现在：①对血液循环的调节。由于肝具有藏血和调节血液的功能，故可根据人的不同活动情况，以调节血液的需求，如人活动时血液循环行于诸经脉，人卧时血液内归于肝。血液或行或藏，亦由肝气的正常疏泄来实现，唐容川说：“肝主藏血焉，至其所以能藏之故，则以肝属木，木气冲和条达，不致遏郁，则血脉流畅。”（《血证论》）②促进机体新陈代谢。出入升降是机体代谢的基本形式，肝除主生发功能外，还表现在它对气机的调节作用。唐容川又说：“木之主疏泄，食气入胃，全赖肝木之气以疏泄之，而水谷乃化。”（《血证论》）这里的疏泄又包括肝敷布阳和之气以运行全身的功能，如水谷精微剽悍行于脉外的“卫气”，则充皮肤，肥腠理，司开合，温分肉以候外，故《灵枢·师传》云：“肝者，主为将，使之候外。”《甲乙经》也说：“五脏六腑肝为之将。”说明肝具有抵御外侮的功能，而这一功能的产生是通过敷布卫气来实现的。又如水谷精微运行全身，或为营，或为卫，或为气，或为血，也需要肝气的疏泄，协助脾气散精，从而“淫气于筋”，以成“罢极之本”。另外，机体代谢过程中废物的排除，也是藉肝气疏泄的作用，诸如水气潴留，痰浊内生，瘀血阻滞等证，在一定程度上也与肝失疏泄有关，《医阶辨证》谈到，肝气郁滞，可使“六腑传化失常”。

3.肝主运动

运动是生命存在的形式，举凡目视、足步、掌握、指摄以及肢体的各种运动，都与肝的功能有关，《素问·五运行大论》云：“肝在天为风……其用为动。”肝之所以主运动，一方面是通过它所主的筋及筋膜以联系机体的骨干、关节、肌肉，形成肢体运动的主要关键，俗云：“筋长则力大”。故肝主筋与筋膜，而获“罢极之本”的称呼；另一方面由于肝藏血，目得血而能视，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能摄，由此可见，肝血对机体的运动功能所起的作用是很重要的。

4.肝主藏魂

中医认为：神是指人体的精神活动，魂则是神之用，藏于肝，故“随神往来者谓之魂”（《灵枢·本神》）。意思是说：“由于魂藏于肝，藉肝血之潜敛，则魂安不扰，随神以动，任物之味，故依附于神，而主宰着人的精神情志活动。”

如上所述，肝在人的生命运动中，不是一个简单的解剖学概念，而是具有生发、疏泄、运动、藏魂等特点的一个多能脏器。

必须指出的是，功能是物质存在的方式，物质是产生功能的基础。肝的物质与功能的关系反映肝体与肝用的辩证统一之中。肝之血、阴谓之肝体，是资助肝用的物质基础；肝之气、阳，谓之肝用，是对肝阴产生作用的必要条件，故肝的生理特点，古人称之为“体阴而用阳，”然阴阳两方必须保持对立的统一平衡，才能使肝气调畅而不病。

肝属五脏之一，其功能的发挥要在他脏的作用下，才能得以实现。华岫云说：“肝为风木之脏，体阴而用阳，其性刚，主动主升，全赖肾水以涵之，血液以濡之，肺金清肃下降之令以平之，中宫敦阜之土气以培之，则刚劲之质，得以柔和之体，遂其条达畅茂之性。”（《临证指南医案》）因此，我们不能离开其他脏腑孤立地去看肝的生理作用，也就是说，必须从藏象学说的整体观念和对立统一规律中，去看待肝在生命运动中的作用。

二、肝病的病变规律

肝病是指肝的生理功能失调所引起的一切病证的总称，它包括肝的功能和器质两方面的病变。中医认为：各种症状的出现，都可根据五脏所属，来揭示五脏生理、病理特点，而把握其生理、病理特点，可以掌握脏腑病的病变规律。例如：肝为风木之脏，主筋，凡有振掉、强急、抽搐、动乱、急迫等病象者，都属于肝；肝为将军之官，藏魂，在志为怒，凡情志改变中的郁怒等所致的病变都属于肝；肝藏血，凡血证因郁怒而起者都属于肝；肝位胁侧，凡胁下病变诸如疼痛、痞块等无不与肝有关；肝喜酸，凡泛酸暖气皆属于肝；肝胆相连，凡口苦、睛黄、黄疸、视物有晕而模糊、惊狂等，都属于肝。凡此等等，把握了肝病这些变化规律，并进而区别其中主次、标本关系，就可以触类旁通，活泼地掌握肝病的辨证论治了。

然而，应当看到，在疾病的发生发展的过程中，病因是本，病症是标，辨证时“必伏其所主而先其所因”，因此，认识肝病的病变规律，还应当从病因、脏腑经络的传变规律、病理特点等方面作进一步的探讨，现分述如下：

（一）病因特性对肝脏发病的影响

病因学说认为：病因的分类可分为内因，外因和不内外因。这种病因的分类法也适用于肝的病因的分类。尽管各种致病因素的性质不同，所表现的病证特点也因之而异，然皆有一定的规律可循。肝病的病因牵涉面广，病变也较复杂，但是，六淫中的“风淫”，七情中的“怒”和情志抑郁，以及不内外因中的“酒毒”、“痰浊”、“瘀血”、“房室”、“外伤”等，对肝病的发生具有特异的关系，在辨证论治中极有参考价值。

1.六淫发病于肝

风属阳邪，性主开泄，喜行而数变，然“风气通于肝”，故“风气”为厥阴肝木之主气。《素问·六微旨大论》说：“厥阴之上，风气治之，中见少阳……此为本也，本之下中之见也，见之下气之标也”。可见，厥阴以风木之气为本，故肝病可产生“肝风”之变。一般而言，肝风属内风范畴，因“风气通于肝”，外风可因营卫空疏招致内客于肝，也有热极生风而内外相引者，但不管是内风，抑或是外风，或内外相引，都是表现为“善行数变”，动摇振掉之病象。

其他五淫，湿、热、燥、火、寒邪，每多以风邪兼挟而发病于肝。例如：风火为患，可因风乘火势，火借风威，导致肝脏升发、疏泄，动摇太过而为病；寒与湿为患，凝敛黏腻兼挟风邪为其间，可牵引肝之升发、疏泄的功能而为病；“燥”为津液不足之象，有温燥、凉燥之分，风挟燥热则消灼津液，风挟凉燥则津液不布，无论是消灼津液，或津液不布，都可致肝的体用失调而为病。

2.七情致肝为病

人的精神情志活动过度，可伤及相关的脏腑而发生各脏之病。如怒为肝志，其气刚暴，容易导致肝病。因怒则气血逆乱，而使肝失去疏泄条达之用。石念祖说：“人忿则全身气血颠倒，最易伤肝。”（《王孟英医案释注》）并且，气血逆乱以后，轻则“气盛而胸胀”（《灵枢·论勇》），重则“血之与气，并走于上，则为大厥。”（《素问·调经论》）表现出突然昏仆，不省人事的多种厥证。如果影响到藏血功能，还会表现出血溢于脉外诸证。如上逆则为呕血，下迫可为崩漏。若大怒气逆乘侮脾气，也可以出现完谷不化的飧泄之证。并且往往因气逆化火，导致肝魂不能戢敛而生怒狂之变。

由此七情致病，都会导致气机紊乱，影响血液失调。因此，悲、忧、恐等情志过度都可使肝为病，王孟英说：“肝主一身之里……七情之病必由肝起。”（《王孟英医案》）如“恐则气下”（《素问·举痛论》），因恐则气怯，气怯则下行，因而使肝的升发受到抑制；“悲则气消”（《素问·举痛论》），气消则使肝气内夺，可使肝魂不藏，所谓“肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂妄不精”者是矣；“惊则气乱”，气乱则神魂无主可使肝胆之气内消，而产生惊悸与惊狂等证；“思则气结”，气结则肝气内郁，而使疏泄不利，多表现为饮食不思，胸胁胀满证。以上说明了怒可导致肝病，其他情志也能使肝气为病。因此，需要针对肝脏为病特点，结合具体证候考虑问题。

（二）肝病脏腑经络的传变规律

人身脏腑居里，经络居表，经络是脏腑表里配属的纽带，脏腑是经络气血循环的根本。形骸五官关系脏腑所主，躯体部位则关系经络沟通。因此，脏腑经络是一个整体，并具有不同内涵的概念，它们具有不同的生理功能。

经络有“行气血，营阴阳”的生理作用，又是反映脏腑的生理、病理变化于外的通路，因此，发病之初，经络脏腑可以相互影响，在发展过程中又可以相互传变。比如说，外因之疾多先发于体表，由经络而内传脏腑；内因之疾初起多先表现于内，由脏腑而外达于经脉（如表里同病则内外并重）。所以，在认识肝病变化规律的同时，不能离开脏腑经络的病理反映。下面就肝病的传变规律分别论述如下：

1.经脏互传

经脏互传是指脏及其所属经脉可以互为传变。既可先有经脉病变，而后传脏腑，也可先有脏腑病变，而后传经络。肝属厥阴，肝之脏病可以导致足厥阴经脉病，足厥阴经脉病也可以影响肝病。如《伤寒论·厥阴篇》第351条云（按赵本号码）：“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。”此证为厥阴血虚而寒邪客于经脉，故用当归四逆汤滋血以温散经中寒邪；而第352条又说：“若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。”这说明寒中于经与寒邪犯脏在治疗上有相同之处。又如第378条说：“干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。”这一条就反映了肝脏寒邪而又外及于经络的证候，而有互传的病变规律可循。至于因经脏互传，在内外出入之间，常可扰及所系属之五官（眼、耳、鼻、舌、口），五体（皮、肉、筋、脉、骨）而发生病变。如“肝病者眦青”（《灵枢·五阅五使》）；“肝气热，则胆泄口苦，筋膜干，筋膜干则筋急而挛，发为筋痿。”（《素问·痿论》）可以看出，这些病变的发生，实与“肝开窍于目”、“肝主筋”有内在的联系。

2.经脉互传

经脉互传是指本经病变不愈，传与另一经为病而言。如足厥阴经脉属肝，它的传变规律有手足两经相传（即肝传心包或心包传肝），有阴阳表里相传（肝传胆，或胆传肝）。《伤寒论·厥阴篇》第326条说的“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热……”就是足厥阴肝病，而上犯于手厥阴心包的一个说明。至于表里相传，是指厥阴与少阳相表里，少阳之邪，若不从表外解，则易于内陷厥阴而为病，而厥阴之邪内溃亦可从阴出阳而出现少阳证，所以，表里相传是肝病传变中一种多见的形式。

3.肝病传变特性

肝，干也，其特性每以干犯他脏为能事，如上侮肺金，下竭肾阴，中伐脾胃，不一而足，其中尤以肝病传脾和肝病及胆，或肝胆同病，在临床上尤为常见。

应当指出，肝病传变并不是固定的模式，在传变过程中，常常受到多种因素的影响，如时令气候，“春善病鼽衄”（《素问·金匱真言论》）；体质因素，“木形之人……其为人苍色……能春夏不能秋冬”（《灵枢·阴阳二十五人》）；又如情绪突变，“五志内伤，故令不得以次传”。凡此等等，说明了肝病传变和时令气候、体质因素及精神因素等影响是分不开的。

（三）肝病病理变化特点

上面谈到，由于病因的特异性，和病因中的阴阳偏盛关系，可使肝病依据经络脏腑的内外表里关系进行传变。如病进则由表入里，病退则由里达表，所以肝病在变化中有其一定的特点。

1.肝病的基本矛盾在于体、用失调 肝属厥阴，厥阴为两阴交尽，一阳初生，故体阴而用阳，发病则以“体”、“用”失调为基本矛盾。并且，可因阴阳互相消长而出现阴阳夹杂之象。

肝为风木之脏，然木能生火而水又能生木，故肝木介于水上火下之间，发生两种不同的母子关系。若肝之阴阳失调，就会扰乱母子两脏的安全。所以，它既可挟水而动，也可挟火而动，使阴阳水火不得交济而

为各种病证。

2. 气血病证是肝病的主要临床表现 肝为多血少气之脏，病则血常不足，气反有余，“气有余便是火”，火盛而更易耗血。而且气郁则血滞，所以在肝病的过程中，初起只涉及气分，若气分羁縻不愈，则入于血分。例如肝阳升发太过，则使气血上冲而病厥，若肝风上扰则见头目眩晕，或跳痛；如挟火热，则两目红赤胀痛、颊赤；又如涉及少阳之经，则两耳疼痛；若气病及血，可出现咯血、呕血；若肝血内虚，不能藏魂，则出现多梦易惊等证；若阳气升发不及，则清阳不易上升，而必见病起则头眩、痛而喜按、面色青白、两目眊眊无所见等证；若肝气不升，脾虚下陷，又可见洞泻肠鸣、嗜卧善恐等证；如肝阳化风，而风挟燥热，也可见到消渴善饥等证；此证若在妇科方面，更见于月经前期，经量为多，甚则发为崩漏之证；若因肝气郁抑，则见胁痛、腕闷、暖气太息；若内挟瘀血，则见腹内坚硬、月经愆期、腰腹疼痛等证；若气不疏泄，三焦不利，则小便不利。

三、肝病的诊断学特点

诊断学认为：从诊察疾病显现在各个方面的客观症状，可以帮助了解疾病的原因、性质及内在的联系，从而为临床辨证提供依据。因此，我们在了解肝的病变规律的基础上，进一步掌握其诊断学特点，包括四诊观察和肝病特有症状的鉴别诊断，就会更好地掌握肝病的辨治。

（一）四诊对肝病的诊察

1.望诊

以五色命脏，则青为肝色。临床可依据青色的明晦含露与所见部位，来分析肝病的寒热虚实和预后转归等变化。以常变而言，面色明润，隐含微青之色，为其常，《素问·五脏生成》曰：“生于肝，如以缟裹绀”，说明青色隐然内见，即是肝脏所见于外的正常色泽。若颜面青色而晦滞，毫无光泽，即为肝病之色，且又提示了病情危重，所以《素问·五脏生成》又说：“青如草兹者死”。如青色显露不失常润，病虽较重，仍有较好的转归，故又说：“青如翠羽者生”。可见诊察青色的明暗、枯槁、显露，能够诊断肝病的轻重顺逆。以青色所见部位而言，如小儿两眉间（印堂）青色暴露，则为惊忤伤肝，或肝风易动之象；若面见青色或太阳穴部位见青筋的，则为急惊风预发之兆。余如目青多为风寒，唇青紫多为血瘀，唇吻反青，四肢~~紫紫~~^{焮焮}者则为肝气已绝。若以兼色而论，如面色青兼白为挟寒或脱血；青而兼黑为痛甚；黑而枯瘦则为肝肾将败。在辨兼色时要分清主色和客色，乃是提高诊断水平的一个关键。

此外，根据“肝主筋”，“肝开窍于目”，“爪为筋之余”理论，观察目、筋、爪色泽的变化，也可以作为诊断依据。如肝风发动目常眨眨；肝阴内亏则视物不明或雀盲；痉厥将作，目多上视或斜视；若目直视或

正圆，则主病情危重；目青多风寒，目黄多瘀热，目赤多风热，兼肿者系因风火交煽；目涩而痒者多病有虚风；爪甲枯槁提示肝热。甚则舌体的变化，也可作为诊断肝病的依据，因足厥阴经脉络舌本，故凡见舌卷、强硬、短缩、萎缩，或伸出颤抖、歪斜不正等态，都与肝病有关。

更有意思的是，对机体外在的体形、动态、肢体运动状态及精神面貌的观察，也能为肝病诊断提供依据。如《灵枢·本脏》云：“青色小理者肝小，粗理者肝大，广胸反骹者肝高，合胁兔骹者肝下，胸胁好者肝坚，胁骨弱者肝脆，膺腹好相得者肝端正，胁骨偏举者肝偏倾也。”《灵枢》这一记载，虽然还需要加以临床验证，但它说明中医的体检要求还是比较具体的，其目的就是为诊断疾病提供依据，当然精神状态的诊察则更为重要。所谓望神，是指观察病人精神意识的变化。古人说“得神者昌，失神者亡”，说明望神的重要性。如肝病所致的昏迷，可见到循衣摸床，两手撮空等无意识举动，肝风内动的痫证，可见突然昏倒不省人事，口吐涎沫，两目上视，四肢抽动，鼻息必鼾，或见精神烦躁与易怒等病证。由此可见，通过观察精神变化，判断肝脏阴阳气血盛衰的病态和预后，这对临床来说是有指导意义的。

2.闻诊

病人语言、声音、气味的变化是疾病的客观反映。根据中医学肝“在音为角，在声为呼”，“肝为语”等有关理论，通过对语言、声音、气味的观察，可以帮助判断肝病寒热虚实的变化。如从声音高低不同可辨虚实，小儿阵发性惊呼，发音尖锐，惊恐，多为肝风之证；成人下利矢气，辟辟有声而粪色青者，亦多与肝风有关；盛怒之下，大声疾呼，多属肝实之候；时发太息，长声短叹，多属肝郁之候；如呃声高而短，响亮有力，或呕吐较猛，声音响亮有力多属肝火冲逆之候；若呃声低而长，且微弱无力，有时则见于肝寒冲胃之变；若以语言变化而言，声高有力多为实热，狂言骂詈不避亲疏，多系肝经实火所致；若语言低怯，或说话断续不接，或颠倒错乱，喋喋不休，喃喃不止的又多属肝经虚热之证。

肝病患者的口气、汗气、排泄物等，也有其特殊表现。如肝经之证易排泄酸腐臭恶等物，或小便臊臭特甚，或淋浊带下，臊臭特甚。无论口气、汗气，或二便的气味，只要嗅到酸或臊臭味，即可作为肝病的诊断依据。

3.问诊

问诊是中医诊断学的一个重要方法。对肝病患者进行问诊，应在抓住肝的主证前提下，追询其自觉证候和病情喜恶，判断它是否与肝的发病有关。如以头痛为例：首先辨明病位究属何经，如头痛在巅顶部位，可以认定它是肝经的头痛，因为足厥阴肝经与督脉上会于巅，而肝之风木之气又有向上升发的作用，所以，多与肝经风阳上冒有关。在此基础上，应探索病情是否肝风病中而有兼挟之邪，例如抽掣作痛的为风重；兼头胀的则多挟风热；痛如雀啄的多为风火；头顶压痛或首如帛裹，则为风湿之邪；若寒湿头痛，则喜热而恶凉；火燥头痛则喜凉而恶热；邪偏实者，则巅顶胀痛不已而手不可近；正偏虚者，则痛而喜按，且时作时止。通过以上的问诊所得、四诊合参，综合分析，作出正确的诊断也就不困难了。

4.脉诊

脉诊是诊断肝病的主要手段之一，所以，重视脉象对肝病的诊察甚为重要。临床上要以脉的至数，脉的形态，脉的幅度等方面进行鉴别分析，以诊断具体病情。以常变而论，正常的肝脉是微弦，“软弱轻虚而滑，端直以长，故曰弦”（《素问·玉机真脏论》），是说脉来稳重，张力柔软，脉波滑利，反映了气血运行通畅，肝脏功能正常。至于肝病的脉象则是弦多胃少，“病肝脉来，盈时而滑，如循长竿，曰肝病”（《素问·平人氣象论》），是说弦脉虽滑而欠柔，脉体长而盈实，触指遒劲。然而，“其气来实而强，此谓太过，病在外”，“其气来不实而微，此谓不及，病在中”。至于肝病的真脏脉，是但弦无胃，只见强硬劲急，状如弓弦，毫无从容和缓之象，所谓“急益劲，如新张弓弦”，其脉预后大多不良。以部位而论，历代医家多数认为关部脉均候肝胆病变，一般左关候肝为主，故肝病左关脉弦。若右关脉弦，多为木克土，兼见腹痛腹泻，腹满胀大等证。如两手关部俱弦，或右盛于左，预示病情已进入严重阶段，病情加深。若以相兼脉象而论，弦数属热，弦迟为寒，弦细为肝血虚，弦细数为肝阴虚生热，弦大数为肝火盛，弦大为邪实，弦涩为血瘀，弦滑为风痰，弦而微浮为厥阴病欲解。凡此种种，弦脉兼见其他脉象，往往提示肝病兼有不同病候。

此外，腹诊在诊察肝病时也具有特殊意义，尤其在肝病发展至肝木

横克脾土的阶段更为重要。一般来讲，肝病继发腹水，以手按其腹皮松软不坚者，多为脾虚不运而水湿停留之证。反之，腹皮紧张，按之坚而弹性，则多为气血水相凝结不散等实证。若腹中胀痛，以手按之腹中有块而固定不移，则多为积聚之变；若肝病而腹部反凹陷不起，以手按之而不柔和，则为肝之气血津液不足的反映。

（二）肝病常见症状的鉴别诊断

由于肝病的病因病机复杂，反映于外在的症状也不尽相同，甚至是千姿百态，错综复杂的。如何在同中辨异，于异中求同，辨别疑似，分析准确，这就需要认真地鉴别诊断。

1. 胁痛

肝在人体的解剖部位居于右胁下而稍偏左，因足厥阴经经脉属肝络胆，布于胁肋，故胁痛是肝病的特定症状，如“肝病者，两胁下痛引少腹”，“邪在肝，则两胁中痛”。证之临床，肝病患者多有胁痛一症，因此，对胁痛的鉴别诊断很有意义。

肝病胁痛的鉴别诊断，应着重辨别痛的性质和痛的部位。比如痛的性质有隐痛、胀痛、热痛、刺痛、坠痛、注痛及串痛等的不同。一般来讲，隐痛即隐隐而痛，绵绵不休，痛时喜按喜揉，舌红少苔，脉见沉细或略数，这种情况多见于肝病病程较长的患者，其痛势往往因劳累诱发，张石顽云：“里虚而痛者，阴不足也。”（《张氏医通》）张景岳也说：“胸胁隐隐作痛，为肝肾精虚。”（《景岳全书》）可见隐痛多属肝阴不足，或水不涵木所致。胀痛是指肝区既痛且胀，胀痛并作，病人多有胸脘部胀满不舒等证，宜从肝郁气滞与湿热壅滞两者进行鉴别；若见胸满不食，呕吐暖气，或腹中胀满，多与肝气横逆，克犯脾胃有关；若见胃呆纳少，呕恶灰油等证，则因肝郁化热，湿热交蒸，疏泄不利为病，其舌苔多厚腻，脉多弦数或弦滑。热痛是指疼痛中灼热感，可于虚实之中进行鉴别。实证痛剧，发病多急，常伴有烦躁易怒、头痛咽干、便干溲赤、舌赤脉数等症；虚证则隐隐作痛，发病缓慢，多见于久病之后，常伴有头晕失眠，口干低热，舌红苔少，脉细数等症。实者多为肝火所致，虚者多属肝肾不足而起。“注痛”是指肝病病人，自感右胁下或剑突下疼痛如有根基，固定不移，随体位变动，或饱餐后痛势加重而言；且常兼见皮肤甲错，面部有蟹爪纹理，舌紫脉涩等症。坠痛是指胁痛伴有沉重下坠感，往往久立痛增，平卧则痛减，喜揉喜按，兼见气短乏力，纳少便溏，脉虚舌淡等症，多为久病之后，肝木乘脾，脾气下陷所致。串痛是指痛无定处，攻冲上下，时发时止，发作多与情志波动有

关，兼有暖气、善太息、舌淡、脉弦等症。刺痛是指痛如针刺、固定不移，兼见舌青脉涩等症，多属血瘀，多为病久由气及血，气滞血瘀而成。亦有虫扰胁痛者，其部位以右胁及剑突为主，多兼有呕吐蛔虫，颜面发生虫斑，痛势有如顶撞感的症状。凡此种种，只要认真诊察则不难鉴别。总的来说，其鉴别重点应分清气、血、寒、热、虚、实。如偏气分的多实，偏血分的多瘀，亦有虚中挟实。如实证患者，误用香燥理气太过，则易向虚证转化，这些证候都是临床应当掌握的问题。至于胁痛部位，也有一侧或两侧之异，肝病胁痛虽然多以右胁为主，但肝失疏泄，两侧攻刺而痛，临床亦不少见。

应当指出的是，胁痛固然是肝病的常见症状，但不能一见胁痛即诊断为肝病，尤其应与风寒、痰饮等证所引起的胁痛相互鉴别。其要点在于：肝病胁痛往往有较明显的情志过度刺激等诱因。有情绪不稳定、性急易怒表现，且易引起脾胃方面的症状，如胁肋隐痛、腹满、纳呆、肠鸣、便泻、倦怠乏力等症。痰饮胁痛，其痛多满痛而胀，伴有咳吐痰涎，呼吸咳嗽则疼痛加剧；风寒胁痛，痛势阵发短暂，多伴有寒热往来、口苦、咽干、目眩等症。这些只要在临床上认真辨证分析，就不会发生误诊。

此外，胁胀也是肝病常见症状，易与胁痛同时存在，痛而兼胀，或由胀而痛。所谓“肝壅、两胁满”，说明胁胀多见于气滞。不过单纯胁胀的出现，多数在病的初期或后期阶段，肝病初起，胁胀多为胁痛的前驱症状，其程度可以上及胸膈，下连少腹，而以实证多见；肝病后期，由于久病正虚的缘故，胁痛解除后，往往遗留下隐隐胁胀，多属虚中挟实，以血虚挟瘀尤为多见，这在临床上是很有诊断价值的。

2. 黄疸

黄疸的出现，多为湿热或寒湿内蕴而生。如湿热发黄的则为“阳黄”，寒湿发黄的则称之为“阴黄”。肝病而有黄疸，因肝胆互为表里，肝病若影响胆汁排泄功能失常时，则可发生黄疸。喻嘉言说：“胆之热汁满而溢出于外，以渐渗于经络，则身目俱黄。”（《寓意草》）肝病继发黄疸非单纯湿热所引起，还应注意与瘀血、寒湿、疫毒等因素有关。鉴别诊断，凡身目黄色鲜明、小便短少、色黄赤者为湿热黄疸，兼有心中懊恼、腹胀、便秘、舌红、苔黄腻、脉弦数为热重；兼见身热不扬、黄色滞晦、头身困重、脘痞腹胀、口淡不渴、苔黄厚腻、脉象濡

缓者为湿重。若症见身黄、少腹硬满、小便不利、黄色兼黑、目青面黑，或心中如瞰蒜薤状、额上黑、足下热、脉沉结等症，则为瘀血黄疸，多为瘀血湿热相合，阻滞肝胆所引发，肝病后期此证比较多见。寒湿发黄，每以脾阳不振，寒湿郁滞为主，多兼有纳少、脘闷、腹胀、大便不实等症。疫毒黄疸是肝病中最急剧的一个类型，多具有发病急，病势重的特点，常突然身黄，迅速加深，黄色如金，胸满气喘，高热烦渴，尿如柏汁，腹胀胁痛，神昏谵语，脉弦数或细数，舌红绛，苔黄燥，吐衄便血，或见斑疹，或见腹胀昏迷等证；病因为感受“天行疫疠”之气，热毒之邪，化燥而劫伤肝血，或迫血动血，或内陷心包所致。总之，肝病发生的黄疸不可概以湿热、寒湿而论，因此，进行鉴别诊断实是提高辨证论治水平的关键。

3.乏力

乏力是指肝病患者自觉四肢倦怠，周身无力，懒言少动的病象而言。因“肝为罢极之本”，主一身筋脉及肢体的运动，所以肝病可以使机体耐受疲劳的能力减低，而显示体疲乏力的症状。经临床观察，肝病的任何阶段都可以出现疲劳和乏力的征象。其鉴别诊断之法，宜分清虚实两端，虚证有肝气虚、肝血虚、肝肾两虚之别；实证有气滞、血瘀、湿热蕴结之分。肝气虚者易见周身倦怠，肢体软弱，不耐劳动，动则气喘，心悸，自汗，易受外感。因肝主升发之气，若肝之生化不足，则脾胃运化功能受影响，四肢的运动、肌肉脏腑的营养受到限制，故呈现倦怠、乏力的症状。黄元御云：“肝木生于肾水而长于脾土，温和则肝木发荣，太静则风恬水寒，土湿不能生长……”生气不足者十当八九，木气抑郁而不生是以病也。”以上讲的是肝气、肝阳的生化功能不及之虚。若肝血虚的乏力症，则多见头晕、视物昏花等症，并且下肢乏力，伴有似痛非痛，似麻非麻之感，甚或筋脉发生拘急。实证之气滞、血瘀、湿热蕴结，在病变中虽然可以互为因果，但在鉴别诊断上仍有不同的区别：如气滞倦怠乏力，多伴有肢体酸胀，关节串痛，卧床休息反而加重，运动后则反稍轻的现象。此证多见于肝病初起，因肝气郁滞，血行不畅所致。血瘀倦怠无力，具有明显瘀血体征，且四肢酸痛，或伴低热等证。缘因肝血虚而不行，筋脉失养所致。湿热乏力多伴见肢体沉重酸楚、头痛如裹、小便黄赤、或目黄身黄，多见于湿热蕴郁肝胆，肝疏泄失职，气血阻遏经脉，是以乏力。总之，肝病乏力不可一概责之于虚而妄投补剂，仍宜细心鉴别，才能提高临床疗效。

4. 头痛眩晕

头痛眩晕也是肝病的常见症状。因足厥阴肝经经脉上络巅顶，故其头痛多以巅顶为甚，又肝开窍于目，肝风又多上扰，故眩晕多为阴虚阳亢，下虚上实之证。两者常合并出现，也可以单独出现。头痛眩晕同时存在，多见于肝热或肝阳上扰之证，兼有头之两侧太阳穴胀痛，眩晕如坐舟中，多为阳用过极，疏泄太过所致。《素问·五常政大论》说：“肝疏泄太过，易掉眩鼓栗，筋痿不能动。”当然，少数患者亦可因肝血或正气不足所引起，多兼见头顶痛甚，头晕眼花，心悸不寐等证。故《至真要大论》又说：“肝疏泄不及，头顶痛重而掉眩。”

肝病头痛要注意从肝郁、肝热、肝阳上亢、肝寒、肝火等方面进行鉴别诊断。其鉴别要点在于：肝郁头痛，多在一侧，因精神抑郁诱发或加重，兼见胸肋胀满，脉沉弦等症；肝风头痛，痛多在巅顶，伴头皮抽掣或有蚁行感；肝阳上亢头痛，痛多兼胀，伴有耳鸣目赤等症；肝寒头痛，虽也多痛在巅顶，但多有呕吐稀涎，脉弦缓等症；肝火头痛，痛势急剧，伴心烦目赤、口苦易怒等证。诚然，头痛除肝病中常见以外，他如内因髓海空虚等，亦可引起。

肝病眩晕，可参照肝病头痛进行鉴别，不过眩晕的出现比较易见于肝风、肝阴（血）虚的患者，肝风引起常由阴虚阳亢，风阳旋绕所致，必有抽掣、动摇之象；肝血不足，多伴有面色苍白，心悸失眠，手足发麻之症。

5. 腹胀

腹胀是指肝病患者出现脘腹胀满而言。因足厥阴肝经经脉“循股阴入毛中，过阴器，抵少腹”，故肝病腹胀以少腹胀满为多见。肝病腹胀亦有虚实之分，实证以肝经气血瘀阻，因而出现胀满之证。凡因气滞所致之腹胀，多以食后较甚，有明显的肠胃症状，肠鸣漉漉，矢气则腹胀较松；因瘀血所致之腹胀，则见腹皮脉络怒张、面色黯黑、唇色紫褐、肌肤甲错，反映了肝经瘀血而致经脉失养。至于肝肾阴虚之腹胀，属于虚证，可见面色晦滞，口燥咽干，腹部独大，叩之空空然不实，且逐渐积水，这种脾不健运，气聚水停的腹胀，也要分辨脾肾阳虚和湿热的孰

轻孰重，兼脾肾阳虚者多见纳呆、便溏、肢冷、恶寒等证；兼湿热者，多见脘胀撑急、烦热口苦、小便赤涩、大便秘结等证。

此外，腹胀有时也偶见腹痛、腹胀并存者，这在肝病中多见于气滞血瘀，《灵枢》云：“眇络季胁，引少腹而痛。”妇人经带胎产亦不乏其例，与肝失疏泄有关。

6.抽搐、囊缩

抽搐是指四肢抽搐、拘急搐挛而言，囊缩是指阴囊缩入而论，两者皆为肝病常见症状之一，多见于肝病的危重阶段。抽搐多因肝风内动所引起，由于“动风”的原因不一，抽搐的表现也不尽相同，如阴血亏虚，不能濡养筋脉的抽搐，可见手足拘急不宁，初起但见手指蠕动，严重时即成“痉厥”，伴见手足心热甚于手足背，舌绛脉细数等阴虚见症；热盛动风，因热伤津液，筋脉失养，以致抽搐，多伴见抽搐有力，高热，口渴心烦，舌红，脉弦数等症，《素问·痿论》说，“肝气热则筋急而挛”。至于囊缩一症，则有寒热之分，属于寒邪者，因寒主收引，使肝脉不利者有之；属于热邪者，因热伤津液，肝脉失润，而使囊缩。属于寒证则有寒象而舌苔黑滑有津；属热证者则有热象舌苔黑而且燥。然无论寒热何证，凡见到男子囊缩，女子乳缩的皆为危重之候。

7.善怒惊骇

善怒是精神易躁喜怒，虽经劝说也不能自拔。惊骇是善怒的进一步发展，表现于惊惕骇怒，使精神不安。因肝藏魂，怒又为肝志，故善怒惊骇皆为肝病的常见症状，《灵枢·本神》云：“肝气实则怒”。惊骇的出现则又与肝不藏血，或热邪迫血妄行，以致魂无所君，故见惊骇，《素问·五常政大论》说：“肝其病发惊骇”。

以上所举，仅是肝病的几个主要常见症状，在这里需要说明的是：①肝病常见症状鉴别诊断具有一定特点，掌握它对提高临床诊治水平有一定作用；②中医对肝病的诊断，是完全以藏象学说为依据的，所以不能把肝病孤立起来，应当和它所联系的各个脏腑加以有机的联系，如能掌握这两个基本精神，对肝病的诊断就庶几近之了。

（三）气血辨证在肝病诊断中的意义

我们在前面谈到肝的“体”和“用”的问题，肝病辨证的入手处，就是首先分辨气与血矛盾的问题，这因为无论肝病的发展变化如何的复杂，都离不开体、用平衡失调这个基本矛盾。因此，阴阳气血辨证较能概括肝病的演变规律。

气血是构成人体的基本物质，是机体新陈代谢的源泉，而肝的生理功能，无论生发、疏泄、运动都是气血的生化和运动表现。因此，肝病的病理变化无不反映于气血的失调。朱丹溪说：“气血冲和，万病不生，一有怫郁，诸病生焉。”所以，我们认为，气血辨证在肝病诊断中具有积极意义。

四、肝病的治疗原则

王旭高认为：“肝病最杂而治法最广。”后世医家治肝方法甚多，李冠仙订治肝十法，王旭高订治肝三十法，叶天士、黄宫绣、张山雷等对治肝均有独到见解。近代医家如秦伯未提出治肝十六法，岳美中以补、泻、和三法以统之。究之古代医家对治肝方法的分类，存在一个名异而实同，或名似而义异的问题，名目繁多，反不切实用。近代医家虽结合临床进行了比较切合实用的分类，但亦未能取得统一意见，这对初学者来说，易坠雾海，茫茫无所适从。我们认为应根据肝的生理特点、病变规律，掌握其治疗原则，才能执简驭繁，以应变于临床。肝病的治疗原则，概括大要可归纳为：

（一）疏通气血，条达为要

肝喜条达而恶抑郁，郁则经气逆，郁久则血瘀，是以气病可致血病，血病亦可导致气病，所以，无论肝病的初中末任何一个阶段，疏通气血这个原则应贯彻其始终。《素问·至真要大论》云：“疏其血气，令其调达，而致和平。”李东垣作《脾胃论》十分注意疏运肝木；朱丹溪虽善用苦寒却妙于开郁；叶天士创通络法巧寓疏肝，凡此种种，皆贯彻“疏通气血”之旨于其中。这就说明治肝方法虽多，掌握“疏气令调”的原则，使其达到炉火纯青的程度，是提高疗效的关键。

肝病者初伤在气，气机紊乱，继可化火动风，因而疏肝理气是其基本治法。叶天士说：“过郁者，宜辛宜凉，乘势达之为妥。”即便是郁从火化，使用时也应注意“用苦泄热而不损胃，用辛理气而不破气，用滑濡燥涩而不滋腻。”（《临证指南医案·肝火》）若郁久及血，气滞血瘀，疏肝理气，亦有轻重之别，轻则疏气养血活血合用；重则理气活血化瘀同法。若瘀阻络脉，又宜和肝通络，宣通而不辛窜，化瘀而不峻猛。总之，用条达舒畅以复其自然生理之态。

（二）体用结合，补泻适宜

补虚泻实是中医治则学说的核心，肝病治疗落实这一原则主要是指，补肝体之不足，泻肝用之有余。由于药物治疗的目的，是用药物五味之性去纠正脏腑阴阳气血之偏，从而达到恢复脏腑功能活动的目的。所以治疗肝病也必须根据“五味入胃”，“各归所喜”和“各有所喜攻”的理论，去纠正肝之“体”、“用”失调的基本矛盾，使其平衡，而达到治愈肝病的目的。

五味归经学说认为：酸先入肝。《内经》提出“肝欲酸，急食酸以补之”，“肝苦急，急食甘以缓之”，“肝欲散，急食辛以散之，以辛补之，酸泻之”的原则。这里的酸、辛、甘是指药物的五味，“欲”和“苦”是指肝脏的性质，说明辛散、甘缓、酸收是调整 and 恢复肝的功能活动的原则。但要说明的是，对“补用酸”与“酸泻之”，“以辛散之”与“用辛补之”，应有一个正确的理解。“酸”补是指运用酸性药物补益肝体而言，后世的酸甘化阴即是；“酸泻”是指运用酸性药物收敛肝用太过而论。因此，两者一言其体，一论其用，皆从体用角度去调整基本矛盾。“辛补”、“辛散”也是这个意思，“辛补”是指助肝阳（气）之用，“辛散”是指疏泄肝气之太过。王冰指出：“木性条达，辛散则助用事之能，所以说是补；酸收则违犯其条达之性能，所以说是泻。”（《重广补注黄帝内经素问》）可见，五味补泻之用，皆以调整肝之体用矛盾为出发点。至于“甘缓”一法，是指甘缓以建立中气，使肝病不能传脾而论，缓肝之传变，如急躁善怒伤肝，运用甘缓的药物以建立中气，使中气健，则肝病可愈。故《难经》指出：“损其肝者缓其中”，仲景主张“益用甘味之药以调之”，都是从这个角度提出的。

肝有气血阴阳，肝之气血阴阳失调皆可导致肝病。因此，补肝之法，实为临床所不能偏废。历代有人执“肝有泻无补”之论，实是不当补而误补后的错误结论。黄宫绣说：“昔人云，肝无补，非无补也，实以肝气过强，则肝血不足，补之反为五脏害，故以无补为贵。诂识肝气不充，是犹木之体不振而折甚易，非不用以山茱萸、杜仲、续断、鸡肉壮气等药以为补，乌能制夭折之势乎？肝血即竭，是犹木之鲜液而槁在即，非不用以地黄、山药、枸杞以滋其水……其何以制肝燥之害乎？”（《本草求真》）其实，临床上补肝气，养肝血也是常用的法则。

肝气横逆窜扰，或肝风内动冲逆，大都属于肝用太过，多为实证。治宜泻实，有平肝、镇肝、清肝、泻肝、化肝诸法之立，这都是根据《内经》“高者抑之”、“惊者平之”、“寒者热之”等原则发展而来，临床

上运用恰当，效果尤佳。

但是，使用补泻法则的时候，要掌握运用标准，不当补而补之，往往敛邪为害，不当泻而泻之，易犯“虚虚”之戒。尤在泾说：“盖脏病惟虚者受之，而实则不受，肝邪唯实则能传之，而虚则不传，故治肝实者先实脾土，以杜滋蔓之祸；治肝虚者，宜补本宫，以防外侮之端。”（《金匱要略心典》）这就说明，补泻的运用，必须恰到好处，才有益于治疗。

（三）明辨标本，缓急有度

《景岳全书》说：“本为病之源，标为病之变。”病因为本，证候为标，肝病的发生也和其他疾病发生一样，先有正气内虚，抵抗能力低下的内在因素，所谓“邪之所凑，其气必虚。”但在肝病的发生发展过程中，由于不同的阶段，表现出不同的病症，因而标本可以互相转化，如肝阴不足、风阳内动，风阳之症为标，肝阴不足是本，但治疗时宜急则治标，必须先平肝潜阳以熄风阳，待风阳熄，再培补肝阴以疗其本。又比如肝病黄疸，湿热郁遏为标，肝疏泄失职是本，也必须清利湿热，解毒退黄以治其标，待湿热解除后，再疏利肝气以治其本，当然必要时可标本兼顾。若肝血不足，仅见头晕、心悸、不寐等症，病程较久，宜遵“缓则治本”的原则，滋补肝血，待肝血得充，则标证自解。由此可见，标本不辨，则缓急难分，只有明辨标本，才能主次有序，治疗上泾渭分明。

（四）整体治疗，疗养兼顾

肝病的病变，虽然主要是肝功能失调，但因为五脏是一个整体，脏腑之间相互影响，因此，肝病可影响他脏，他脏有病亦可影响到肝，所以治疗肝病，不能见肝治肝，而应当“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”（《金匱要略》），即是说应从整体出发，协调各脏腑功能，才能达到治肝目的。例如：水衰木无以生，地黄丸滋之；土衰木无以植，则参苓术草以培之；血虚有火，用丹栀逍遥散以清之；血虚无水，四物汤以养之；补火之法，下同乎肾；泻火之法，上类乎心……等等，都是从整体出发而确立的，从而达到恢复肝功能的目的。

此外，调动机体自身的抗病机能也是很重要的措施，尤其肝脏寓一阳生生之气，不适宜大量苦寒攻伐克削药物，反损生阳之气，使病迁延难愈，病去七八，即当停药以调养，所谓“必养必和，待其正气来复”，这一点应引起临床医生高度重视。

肝病多起于情志不遂，临床医生除用药物治疗外，还须言语开导以治其心，随机“辨病”以开其邪，才能达到事半功倍之效，所谓“心病还须心药医”者是也。

中篇 肝病证治规律

中医的辨证方法，虽然多种多样，但都以脏腑经络、营卫气血为辨证基础。然而，由于脏腑的各自特点不同，以及发病的原因各异，从而决定了不同的辨证方法。其中值得一提的是，气血与肝脏的关系十分重要。因肝主藏血，气主疏泄，故肝病的证治规律应以气血的病理变化为蒿矢。且肝以血为体，以气为用；肝主藏血，故肝得血而气始柔，如肝不得血养，则肝气无偶，势必横逆而为病。识其理者，则养血以疏肝，用血以治气；昧其理者，惟知疏气而不知养血，则肝病难愈矣。为了说明问题起见，现将肝病的证治规律，逐一分述如下，以资临床参考。

第一章 肝气郁结证治

肝司疏泄，气以条达为顺，一有抑郁，则气郁为病。大凡肝病初起，在经在气，故先见肝气郁结之证。

郁结，是指气机壅滞不利而言。戴思恭曾下了一个定义：“郁者，结聚不得发越也，当升者不得升，当降者不得降，当变化者不得变化也。”（《金匱钩玄·六郁》）肝脏本是生机勃勃，主生主升，一旦气机郁结，就会使生、升失司，从而表现出肝气郁结的证候。

中医有“五郁”、“六郁”等说，而与肝郁的概念有别。《内经》分木、火、土、金、水五行之郁，由于五行相因，五郁先始于木郁；朱丹溪立气、血、湿、痰、火、食六郁之论，然六郁互变，也先始于气郁。因此，五郁、六郁与肝郁，名虽有异，但实质上有其内在联系，故前人有“万病不离于郁，诸郁皆属于肝”之说。

正因为肝为多气易郁之脏，肝郁先始于气，所以，肝病的发病规律，不论是外来之邪，或内生之病（包括肝炎在内），它首先表现的证

候就是气机不条达，疏泄失常的病证。现具体叙述如下：

一、肝气抑郁

症状：胸胁发闷，甚则胀痛，不欲饮食，善太息，面色发青，神情默默，舌苔薄白，脉弦。

证候分析：肝气郁结，疏泄不利，则胸胁发闷与胀痛；肝气郁则使脾胃不和，故不欲饮食；气郁胸脘，故欲太息以伸其气，气得舒则胀闷减。反映于色，则面青，反映于神，则神情默默，反映于脉则脉弦。

治法：疏肝理气解郁。

方药：柴胡疏肝汤。

柴胡12克，白芍6克，枳壳6克，茯苓10克，香附10克，郁金 10克。

方义：方中以柴胡疏肝，白芍平肝，两药相合，以治肝气之郁；枳壳利气下行，郁金、香附解郁以开胸脘之满，茯苓善治结气而利三焦水湿，共奏疏肝理气解郁之功。

肝气抑郁，始于气分，多见胸胁胀满，甚则刺痛，时欲太息，苔白，脉弦等症；因气机郁结，不达于四肢，从而表现四肢逆冷。《伤寒论》少阴篇：“少阴病四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。”四逆散所治“四肢厥气”，明显是阳郁不伸之所致。李士材说：“此证虽四逆，必不甚冷，或指头微温，或脉不沉微，乃阴中涵阳之证，惟气不宣通，是以逆冷”。四逆散配伍严谨，深有法度，以枳实之降，散郁热而理脾滞；以柴胡之升，疏肝木而促阳邪外泄，辅以白芍酸收，甘草甘缓，于平调升降之中而寓酸甘化阴之法。药取等量，不偏不倚，免矫枉过正之嫌。柴胡舒肝散，虽出自《景岳全书》，但实是从四逆散中衍化而来。应当指出的是，肝气郁结而表现阳气不得宣通，是临床上常见的情况，不要被“肢厥”假象所惑而误认为阳虚，他如面青，舌苔白，神情默默等气郁不伸之症，皆有鉴别的意义。

【案例】

诊得六脉举之有似沉细，按之数大有力，察其面青肢冷，爪甲鲜红，此火极似水，真阳证也。暂拟四逆散一服，继用大剂寒凉为合法也。

春柴胡12克，赤芍6克，麸炒枳实3克，甘草3克。（《伤寒论语释》）

【按语】

脉似沉细，面青肢冷，貌似阳虚，但脉按之数大有力，爪甲鲜红，显属“真阳证”，然大别于“戴阳”、“格阳”之证，全从“面青肢冷”语出，乃阳郁不伸故也。

二、肝郁挟痰

症状：眩晕，胸痹窒塞，咳痰，噎逆，舌苔厚腻，舌质或红或淡，脉弦略滑。

证候分析：肝气郁滞，胸痹窒塞。气郁后脾失运化而痰生，痰浊上蒙清阳，故头目眩晕。胃本主降浊，肝木犯胃，胃失和降，是以兼见噎气或呕逆。若从热化，则苔厚腻而黄；若从寒化，则苔见厚腻白苔，脉弦滑，是肝郁挟痰之明征。

治法：疏肝理气化痰。

方药：理郁导痰汤。

柴胡10克，香附10克，青皮10克，白术12克，天麻10克，半夏 12克，茯苓15克，陈皮10克，甘草6克。

加减法：兼热者加竹沥、姜汁、贝母；兼寒者加桂枝、细辛、生姜；肝风头痛加钩藤、菊花；中气虚者加人参。

方义：方中以柴胡、香附、青皮以疏肝理气，以二陈汤和胃化痰。诚如叶天士所说：“痰多必理阳明”，“治痰须健中”。故加白术以健运中州，中州健则运化水湿；加天麻以熄风缓晕，以恰合肝郁痰阻病机。

【案例】

刘某，女，34岁，1976年8月初诊。主诉：头晕胸闷，太息心烦，咳痰短气，情怀抑郁，常忽忽不知所苦。舌淡红苔白腻，脉弦滑，辨为气郁挟痰之证，仿理郁导痰汤加全瓜蒌9克、杏仁6克，服药3剂，心胸开朗，继服12剂，病告痊愈。

【按语】

痰气交阻，气结痰凝，而阻碍气机。论治着重疏肝理气，佐以化痰，只有肝郁得伸，气机调畅，痰自不凝，切不可见痰治痰，反生他变。

应当指出：权衡气郁与痰阻孰轻孰重，是治疗肝郁挟痰证很重要的一环。因治气有疏气、降气、顺气、补气之分，因气郁于肝，治宜疏气为主，治痰亦有化痰、涤痰、消痰之别，因脾为生痰之源，故治痰须健中。肝郁挟痰之证，重点在疏肝理气，佐以化痰，只有气顺，方可湿自化而痰自消。

三、肝郁挟热

症状：胸胁胀满而痛，胃脘痞塞，噯气，噯则少宽，口苦，咽干，心烦目眩，舌质红，苔黄白相兼，脉弦细而数。

证候分析：肝气郁结，易挟热而病。高鼓峰指出：“气不舒则郁而为热。”其胸胁胀满而痛，乃肝郁之证；郁而犯胃，则胃脘痞塞、噯气，噯则少宽。挟热则口苦、咽干、心烦；木火上犯则目眩。湿热兼见则苔黄白相兼，脉弦细而数，为肝郁化热之象。

治法：轻清宣泄。

方药：加味四逆散。

柴胡10克，枳壳10g，白芍10克，甘草6克，炒山栀10克，菊花10g，桑叶10克。

方义：肝郁气滞，有化热化火之别，轻重之异。方中以四逆散疏肝

宣通气郁，菊花、桑叶清宣郁热，山梔泄三焦郁火，清胸膈懊恼烦热，全方配伍，共奏轻清宣泄之效。

【案例】

王某，男，48岁，工人。食欲倦乏，肝区疼痛一年余，经传染病院诊为：无黄疸型肝炎，屡用中西药物治疗，效果不显。就诊时见：胁痛隐隐，胀闷，神疲乏力，动则尤甚，胃纳不佳，眠可，便调，舌色暗，苔根黄腻，脉弦细。辨证为：肝郁化热，入络而瘀，治宜轻宣郁热，佐以通络。方选加味四逆散，加僵蚕9克，丝瓜络12克，佛手片6克，薏仁15克，谷麦芽各30克。连服15剂，纳谷转佳，续服 15剂，胁痛已瘥，守方加山药、黄精为丸，巩固疗效，半年后复查，病告痊愈。

【按语】

肝郁化热，仍以治郁为主，既不同于肝火燔灼之证，也有别于热入血室之证，故宜轻透解郁，勿蹈病轻药重之非。本案病程虽达年余，但郁热不除的矛盾不解，只守轻泄，略佐僵蚕、丝瓜络，透中有通，故取效较著。

四、肝郁挟寒

症状：胸胁胀痛，右胁痞肿，纳差，舌淡，苔白润，脉左关弦迟。

证候分析：肝气郁滞，故胸胁胀痛，气病及血，故右胁痞肿（腹诊可见肿大）。肝不疏泄，故胃呆纳差。舌淡苔白润，说明伤阴之象不显露。脉左关弦迟，左关候肝，弦主肝病，迟主寒凝，结合舌苔分析，可见气郁挟寒之证。

治法：化解肝郁，佐以温通。

方药：加味抑肝散。

当归9克，川芎6克，桑钩藤10克，柴胡9克，白术9克，茯苓9克，法半夏9克，橘红6克，炙甘草4.5克，水煎服。

方义：本方系王肯堂《证治准绳》方，后人加入了半夏、橘红。方中以钩藤平肝木，治手足拘挛；当归养肝血，川芎疏气血，与柴胡、甘草、钩藤配伍，具有解肝郁而达养血熄风之妙；茯苓、白术消胃中之水饮；橘红、半夏理气化痰。诸药和合，对肝阳不足，疏泄不及所致肝郁挟寒诸症，均有较好效果。

【案例】

宋某，女性，56岁。自1956年起患慢性肝炎，肝区胀痛，肝功能不正常，肝大4~8厘米，十七年来屡治未效，于1972年8月来诊，切其脉左关浮弦，视其舌苔白润……因投以加味抑肝散作汤用（即上方药量）。服药27剂后，症状好转，肝肿大缩小，又按原方续服20剂，肝功能恢复正常，肝脏已不肿大。（《岳美中医案集》）

【按语】

加味抑肝散亦是从四逆散演变而成，与逍遥散有异曲同工之美。本方系逍遥散去生姜、薄荷，以川芎易白芍加钩藤而成。因为白芍微寒性

阴而与阳虚有碍，故去而不用。加川芎活血行气，后世加入半夏辛燥化痰，陈皮理气，全方作用仍重在化解肝郁，宜于肝郁挟寒之证。其作用既与肝郁脾虚血少的逍遥散证不同，也与肝寒气滞的暖肝煎有别，临床应加以鉴别运用。余曾遇一慢性肝炎患者夏某，工人，31岁，患慢性肝炎已达七年，肝肿大百治不除，屡用苦寒清热解毒，活血化瘀诸法，愈治愈剧，诊时见其伴有肢冷、纳差、便溏，改投加味抑肝散，竟卅剂而告痊愈。

五、肝郁挟食

症状：胸胁胀满疼痛，稍食则胀甚，伴有暖腐吞酸、噫食臭味、时欲吐，舌苔黄腐，脉弦滑。

证候分析：“饮食自倍，肠胃乃伤”。肝郁患者，多见脾胃运化不良，故稍进食即可停滞不化。肝郁气滞，气滞则脾呆，脾呆则不运，是以胸胁满痛，稍食即甚。挟食则暖腐吞酸，干噫食臭，胃气失于和降，故时欲作吐，苔黄腐为食滞不化之证，脉弦滑为气郁食滞之象。

治法：疏肝理气，消食导滞。

方药：柴平汤加味。

柴胡10克，半夏10克，黄芩10克，甘草6克，厚朴10克，陈皮10克，苍术12克，生姜6克，焦楂曲各10克，党参10克，大枣5枚。

方义：柴平汤原载《内经拾遗方论》，用治温疟，一身痛重，寒多热少，脉濡之症。我们根据“疟发少阳”，少阳多郁，湿困脾运，停食而滞的病机，借用本方治疗肝郁挟食之症，亦颇有疗效。方中以小柴胡汤疏肝解郁，和解表里，用楂曲平胃散以消食导滞，对于脾虚不运，湿遏食停，颇切病机。尤其苍术燥湿醒脾，为本方治疗食停的关键，只有气机流通，脾湿得运，则气郁食停之证才得以解除。

【案例】

刘某，女，28岁，农民。正值经行，与其夫争吵，遂常欲叹息，竟不顾行经，入水中作业，致使每次行经之际，先寒后热，寒多热少，有如疟状，伴脘腹胀满，纳呆倦怠，稍食则暖腐吞酸，经色清黑如水，诊

脉濡，察苔厚腻，遂投柴平汤加味，每月经行服3~5剂，两月而瘥。

【按语】

本案先起于郁，继则脾湿不化，经行入水而寒湿外犯，颇切肝郁挟食病机，投柴平汤获效。

六、肝郁挟湿

症状：胁肋胀满，四肢沉重，食欲不振，口腻不渴，时呕恶，腹肿面黄，舌苔白腻，脉濡。

证候分析：肝在一身之里，气郁之后，则使脾运不化，湿从内生。因为气郁，故胁肋胀满；由于湿阻，则四肢沉重，口腻不渴。脾虚则腹肿面黄，食欲不振；胃失和降，则时时泛恶。

治法：疏肝理脾，理气化湿。

方药：加减外台茯苓饮。

党参15克，茯苓15克，当归10克，白芍10克，苍白术各10克，乌梅10克，木瓜10克，青皮10克，柴胡6克。

方义：外台茯苓饮原载《金匮要略》，临床上经过加减变化，用治肝郁挟湿之证。方中以参、茯、术健脾化湿，归芍养血调肝，木瓜味酸敛肝之阴，柴胡疏利肝气。此方补中有疏，敛中有泄，尤以柴胡用量较轻，以升发阳气，从而能使郁解湿除。

肝体阴用阳，喜条达而恶抑郁，一旦肝木失于条达，肝气郁结，必然影响人体脏腑经络而产生各种病症，诚如朱丹溪所说：“气血冲和，百病不生，一有怫郁，诸病生焉。”怫郁可因七情过度伤肝所致，故前人有“郁不离肝”之说。

小结

本章所讨论的肝郁，是指肝疏泄不及，郁在本脏为主。因肝病先始

于气分，故肝病而气必郁。尽管郁不离肝，但因为气机阻滞，可进一步使诸郁相互转化，诸如前人所述：气郁则湿郁，湿郁则热郁，热郁则痰郁，痰郁则血郁，血郁则食郁。但认识前人这种相因为病的格局，宜当活看。因此，我们在叙述肝郁的前提下，有所侧重地对挟寒、挟热、挟湿、挟痰、挟食等兼证，进行了辨证分析，证诸临床，还是有其实际意义的。

应当指出，辨治肝郁要着重明气血、辨虚实。赵羽皇曾说：“肝之所以郁者，其说有二：一为土虚不能生木也，一为血少不能养肝。盖肝为木气，全赖土以滋培，水以灌溉。若中气虚则脾土不升，而木因之郁；阴血少，则木无少润，而肝遂以枯。”（《删补名医方论》）这里谈的是肝疏泄不及致郁之由。因此，我们不能以逍遥散“一方治木郁而诸郁可解”为定法，应当辨证入微，随证立方，才是善治之法。

第二章 肝气冲逆证治

前已述及，郁不离肝。郁则本脏自病，初起始于气分。因“肝者，干也”，若肝气疏泄太过，则易干犯他脏为病，表现出上冲、横逆、下窜等诸种病证。《类证治裁》说：“肝木性升散，不受遏郁，郁则经气逆，为噎，为胀，为呕吐，为暴怒胁痛，为胸满不食，为飧泄，为瘕疝，皆肝气横决也。”

本章所讨论的是指因精神上经受刺激，肝气疏泄太过，气机不和，所出现冲逆诸种病证的防治规律，习惯上也称为肝气病，其辨治既不同于肝郁，又大别于肝火。

肝气冲逆所致病证，虽然比较复杂，但约略而言，有三个明显特点：①多由本脏本经部位开始，以两胁及少腹最为明显，然后循经扩散，上及胸膈，下及前阴等，常常是其来也暴，其去也速；②以实证居多，主要表现为胸胁胀满作痛，少腹胀痛，妇女乳房胀痛等，由于气机阻滞，多见先胀后痛，或胀痛俱甚，初起仍以气分为主，继则病及血分，故有气血分证之异；③易干犯他脏，如扰心、冲肺、犯脾、克胃等，现结合其临床特点，对其证治规律分述如下。

一、气逆本脏

肝气逆郁本脏，多因暴怒伤肝所致，既未冲逆于上下，也未干犯他脏，而是自逆本经本脏，较前述肝气抑郁不同。本证发病急，传变也快，多为实证。

症状：暴受精神刺激，以致胸胁胀满疼痛，先胀后痛，从本脏本经开始，继则可见少腹胀痛，或胸满胀痛，妇女乳房胀痛，脉弦有力，左关尤显。

证候分析：暴受精神刺激，肝脏气机不和，即可出现胸胁胀满疼痛，少腹胀痛，妇女乳房胀痛。左关脉候肝胆，若弦而有力，乃肝气自

逆之象。

治法：轻扬疏达。

方药：四逆调肝汤。

桑叶12克，黑芝麻12克，川楝子12克，钩藤12克，柴胡10克，枳壳10克，白芍12克，甘草6克，夏枯草12克，山栀子10克。

方义：肝郁气逆于本脏本经，气郁则内热，热者宜清，但非外来之邪，芩连等苦寒之品，不能制伏其火，只宜轻扬疏达以平肝气之逆。故方中以四逆散调畅肝气，桑叶轻清走上，川楝子、山栀子、夏枯草、钩藤具有平肝泄肝之能，妙用脂液丰富的芝麻以强阴，是以能轻扬疏达肝脏之逆气。

【案例】

肝郁气逆，脉不应病。同谱王丹文茂才之父，余执子侄礼，少游江湖，其子母，工于心计，故握算持筹资少无缺。晚年出资在永宁州生息，忽为典商负千金，州郡控诉，未获归赵，忧郁而病，兼家务多舛，遂得气逆症。腹满身痛，转侧不安。他医投补剂，转增剧。丹文邀余诊视，其脉多伏，惟肝部沉坚而涩，且三二至辄一息。知为肝郁，因以苏子降气汤合左金丸以进，三服而气稍舒。又视之，肝部有长象，又益颠倒木金散进之，十剂后，腹减而气舒，饮食进，精神作矣。一日留晚餐，座中仍会诊之，脉息如故，余未便明言，归语家人云：三伯肝脏已绝，病恐不起。家人曰：已愈矣，何害？余曰：此脉不关此病，此病乃愈，此脉不可转也。况见肝脏，必死于立春前后。家人以余故神其说，至不信，余遂北上，至冬病作，竟医药无效，于腊月廿四日终于家。余由京归，家人语其事，感诧异焉。（《醉花窗医案》）

【按语】

肝既藏血，又司气机，是藏中有泄，体阴用阳。本案肝郁气逆，气血周流遏阻，脉不应病，肝脉沉坚而涩，气息几微之态矣。先予颠倒木金散而效，终因肝脏已绝，未复生机。这里虽然强调了诊脉的价值，但亦不可舍证而忽视全面互参，积极治疗的意义。

二、气火内郁

因肝气自逆本脏，郁而不透，郁久化火内扰，即可出现气火内郁之证。本证多为肝气冲逆发展至肝火的中间阶段，辨证有其规律。

症状：头目眩晕，胸肋胀满疼痛，口苦吞酸，犯胃则不食不饥，气失温煦，筋不得其养，则筋惕肢麻，严重时影响到血分，气血逆乱，故气噎昏厥。

治法：疏肝清肝。

方药：柴胡调肝汤。

川楝子15克，元胡6克，北柴胡10克，青皮10克，沉香3克，乌药10克，佛手10克，沙参15克，生地30克，赤白芍各12克，丹皮10克，山栀子12克。

方义：方中以柴胡疏肝解郁，川楝子调肝木之横逆，元胡入血以行其滞；沉香降气，得川楝子苦寒之品配伍，则专为行气而不致伤阴；乌药不刚不燥，调肝脾之气滞；佛手、青皮疏肝理气；沙参、生地、白芍益气凉血、养阴以护肝；赤芍活血化瘀，丹皮凉血清热，山栀子清三焦之火，从而疏肝、平肝、调肝相配合成方，有疏肝郁，平肝逆，泻肝水，养肝阴之效。

【案例一】

廖某，男性，48岁。缘于大怒气厥，昏仆倒地，经抢救复苏，继则胸憋如窒，胸肋疼痛，时泛吐酸水，纳差，头目眩晕，如坐舟中，甚则肢麻震颤，语言欠清，喉间似有痰阻，面青晦，血压140/80mmHg，便调，舌质红，苔黄腻，脉弦数左关尤显，证属气火内郁，挟有瘀阻，显系疏泄太过，守柴胡调肝汤加竹茹10克、川贝母6克，三剂，胸脘胀痛明显减轻，他症亦好转，守原方去青皮、山栀子，加郁金、绿萼梅等疏通畅达之品，出入调治半月，复以六味地黄汤加减调理而安。（程西亭老大夫病案）

【按语】

疏泄太过，气火内郁，化风升腾之象已萌，横逆无制，痰热变证之象初显，是以论治从气火内郁着眼，采用调肝气、平冲逆、清痰热之法获效。终以六味地黄汤善后，为治本者设。

“气火内郁”，是肝病发展过程中一个很重要的病理环节。它不同于肝火冲逆之证，肝火冲逆具有冲激之象，“气火内郁”是以“内郁”为主，且有火郁之证。气与火同属于阳，但因气无形可见，火有形可征，“气主煦之”，“火曰炎上”，故其病理上仍有差异，如抑之为气，拂之为火。而气火内郁，则兼而见之，抑而化火，火却未拂而热郁于内，是以气郁而兼内火之证。张山雷说：“肝以气火用事，然火不自动，必气先动，而后火生风生。”（《脏腑药式补正》）说明肝气逆则易继发化火生风之症。但既未见到冲激于上的火象，也未见到升及头巅的风象，所以，“气火内郁”是气郁而致化火动风的病理过程。

调治气火内郁之证，具有“见微知著”的意义。张山雷曾说：“肝气乃病理之一大门，善调其肝，以治百病，胥有事半功倍之效。”（《脏腑药式补正》）善调其肝，就是要正确运用疏肝、养肝、清肝的方法，使气火不致向化火、动风、凝痰、结瘀等方面转化。具体来讲，依据《内经》“木郁达之”，“火郁发之”的原则，可在柴胡调肝汤的基础上，或清泻肝火，或伍潜镇熄风，或佐活血，或配化痰，方随法变，药据证施，法在疏、平、抑、调、柔之间权衡审度，药如辛、酸、甘、苦、咸之中曲尽其变。

临床上运用本方治疗气厥而见“气火内郁”上述诸症，皆有较好效果，但运用柴胡时，不可囿于“柴胡劫肝阴”之说。柴胡专入肝经，具有清泄通达之长，《本草从新》曾云，柴胡“宣畅气血，散结调经”，“人皆知柴胡能发表，而不知柴胡最能和里”。肝病过程中运用柴胡，只要配伍得当，可收到较好疗效，也只要见症不是肝阴大伤，配伍护肝之品，并无劫肝阴之弊。

前人不仅有“郁不离肝”之说，而且有“厥由肝出”之论。这是因为：①从“厥”的含义来说有三种，一为气自下逆上，二为手足逆冷，三为昏仆不省人事。如忿怒引起的“气厥”，证见猝然昏倒，牙关紧闭，手足不温，形似中风；肝阳上扰引起的“晕厥”，证见头目运旋，昏倒不省人事，汗出、面白、肢冷；肝火上冲引起的“薄厥”，证见猝仆面赤，气道不利，喉间有痰声，脉象弦劲而数；肝肾阴虚之内风引起的“痉厥”，证见神昏、舌蹇、烦躁、手足抽搐、时时欲脱。这些“气厥”、“晕厥”、“薄厥”、“痉厥”，均因肝疏泄失调，或肝体不足，故有“厥由肝出”之论。②从病机来说，《内经》虽有“大厥”、“煎厥”等病名，然总不离气并、血并之因，所谓“血之与气，并走于上，则为大厥，气复返

则生，不返则死矣”。由于肝以气为用，以血为体，两关气血，故后人多从调肝以使气血平衡协调，也是“厥由肝出”的理由。临床上常通过治肝以疗厥证，爰录医案两则，以证一斑。

【案例二】

陈姓，江苏人，其爱人病心膈痛，突尔昏迷不知人，不能动，冥然罔觉，延予往诊，其脉参伍不调，时或一止，正思索病来如此之暴，未真正了解，安敢冒昧处方。适见其家属坦若无事，异之。问病者何日起病？曰：昨日尚好，今晨心膈痛，随即闷闭，又问，往日痛过否？曰：痛过，此病已多年，或三五月一发，或半年一发，或一月数发不等，轻则心膈痛，重则痛剧而晕瞀。予曰：往日病发闷闭，如此次毫无知觉否？曰：轻则一时半时，重则二三时方醒。予曰：我知之矣。因思问诊未可忽，望诊尤未可忽，此病苟非查其环境，问其病历，何由知其底细。究之心痛至于暴厥，总属大病。《素问》云：血之与气，并走于上，则为大厥，厥还则生，厥不还则死。此病往日发后，不久清醒，以昔律今，此次亦必不久清醒，但详察经言，亦有不还者，一丝不续则真机绝，不可忽视。因取许叔微白微汤一方：白微12克，当归须10克，人参须6克，甘草3克，加苏合香丸（如大豆大）3粒，分三次化开灌下，隔半时一次，不醒，再服一剂。翌日复诊，云服药二次，未终剂已醒，现已坐立，言动如常。病既愈，以越鞠丸、归脾加减，半调半疏，停药逾一月，其病复作，缘病至肝气较旺，最易动忽，心脑易生阻碍，仍用前方。俟厥回后，再以消瘀导滞，柔筋通络，宁脑宁心为治，仍用白微汤为主，加石决明、龙齿、石菖蒲、天竺黄，又改作丸剂，再加琥珀、熊胆、缬草、朱砂常服，后数月未发，饮食有加，体渐丰腴，不似前之尪羸矣。（《冉雪峰医案》）

【案例三】

宋女，《内经》论厥，不离乎气并、血并两因，气又为血之主，气行则血行，气滞则血滞。据述昨因动怒，猝然晕厥，腹部依然胀痛，信事不行，身热不从汗解，脉弦苔糙。中宫虽有暑湿，而肝气郁结，肝血复瘀，营卫互相乘侮，姑以疏气逐瘀主治，应手为吉。

柴胡、归尾、川芎、川楝、赤芍、桃仁、红花、泽泻、佛手、玫瑰、青皮。（《陈良夫医案》）

【按语】

前述两案，皆诊为厥证，虽不能勾画出厥证全貌，但说明了从肝论治厥证的实践意义。案一先议白微汤益气养血，佐苏合香丸温开，药后一月病复发作，缘于肝旺，最易动怒，乃于白微汤中佐入石决明、龙齿、熊胆、朱砂、菖蒲、天竺黄等品以镇肝平肝化痰，竟达“数月未发”、“体渐丰腴”之效。案二因恼怒气乱，痞塞窍阻，气结血瘀，以疏气逐瘀为治，由此说明，厥证多从肝治。我们还体会到，在厥证发作过程中，气火内郁常常是厥证始崩之机，若能抓住这一病理环节，对防治厥证，可收事半功倍之效。

三、肝气冲心

肝气冲心与肝火扰心不同。在肝病发展过程中，由于肝气逆于心，可使心主血脉功能障碍，若肝火扰心，则易影响心主神志的功能。病理不同，证治各异，这里介绍肝气冲心证治。

症状：心胸憋闷，甚则痛闷欲绝，两胁不舒，腹胀暖气，脉沉弦迟涩，舌边尖青暗，或有瘀斑。

证候分析：肝气逆上冲心，则心血瘀滞，是以心胸憋闷。气滞则血瘀，通则不痛，痛则不通，因不通故痛闷欲绝。因肝气逆郁，故两胁不舒，暖气，及脾则腹胀。脉沉弦迟涩，舌边尖青暗，或有瘀斑，皆为瘀血之确证。

治法：疏肝理气化瘀。

方药：失笑散合金铃子散加味。

生蒲黄10克，五灵脂10克，川楝子10克，玄胡索10克，红花 10克，赤芍10克，川芎6克。

方义：失笑散活血止痛，金铃子散平肝理气活血，合用则心肝同治。红花、赤芍、川芎皆有化痰活血之功，从而使肝气平而心痛可止。

【案例一】

甘肃省，李某，男，58岁。因患“冠心病”来北京住某医院治疗。住院约三月病见好转，而欲返回甘肃，然出院未久，竟因大怒难遏，引起心中疼痛，胸闷气塞，势颇严重，余切其脉弦而迟涩，察其舌质则有指头大瘀血斑数块，辨为肝气冲心，心脉瘀阻之证。急用川楝子散合金铃子散合方，又加香附、郁金，仅服两剂，而痛止气畅以平。

【按语】

《灵枢·厥病》云：“厥心痛……与背相控，善瘕……色苍苍如死

状。”心主血脉运行，但不能藏血，是以卧则血复归于肝，肝脏却只能调节血流量，动则需听命于心，所以肝气上逆于心，易影响心血不运，而出现胸闷胸痛诸症。本案心肝同治，气血双调，就说明了这个道理。

【案例二】

卒心痛。张同志，素患高血压，常服寿比南成药，此次未病前数日，偶尔感冒（与本病无大关系），嗣后发生心绞痛，连及胸背胁腹，日数发不等。痛时如人以手抓心然，面貌变色。自言六神无主，坐卧不安，痛苦难以言状。以病势急迫险重，来中医研究院诊察。诊得脉弦劲中带涩象，盖气血瘀痹，内有郁滞，病根虽久，病发较暴，为卒心痛。予治疗此病分三个阶段，初拟利膈通络，消瘀散结。

处方：全瓜蒌12克，京半夏10克，枳实6克，黄连3克，制没药7.5克，当归10克，石菖蒲3克，川郁金10克，琥珀末5克。

一星期有效，痛的次数少，痛的时间短，大有改善，仍宗前法，加软坚变质之品。

处方：全瓜蒌15克，京半夏10克，枳实6克，黄连3克，吴茱萸2克，当归须、鳖甲各12克，郁金10克，琥珀末1.5克。

又一星期，效显著，病机大缓，症状又见减轻，发作较少，精神亦较好。最后减轻破血药加养血药，减轻破气药加和气药，大药治病，衰半而止，改用半疏半调，渐次由少发以至不发而愈。此病治疗，自初段至后段，前后约一月。（《冉雪峰医案》）

【按语】

本案抓住肝气冲心病理环节，一方面消瘀散结通络，一方面以琥珀平肝安神，获效迅捷。

四、肝气犯肺

症状：突然胸痛，暴然气喘，胸中憋闷，呼吸不利，胸腹胀满，舌苔薄白，脉弦直。

证候分析：肝气犯肺，气逆于胸，胸阳失宣，是以突然胸痛，胸中憋闷，肺气失宣，故暴然气喘，呼吸不利。肝郁气滞，则胸腹胀满，舌苔薄白，非外邪所致，脉弦直系肝气犯脾之征。

治法：疏肝理气，宣肺降气。

方药：三皮汤。

香附子10克，郁金10克，苏梗10克，杏仁10克，陈皮10克，桑白皮12克，瓜蒌皮12克。

方义：方中以香附、郁金理肝气之滞，杏仁、苏梗、陈皮宣肺气之壅，桑白皮、瓜蒌皮清降气火，使肝气平而肺气降，诸症可愈。

【案例】

典史宋晓岚……其媳以恸女故，日切悲哀，兼介人（指介休县人）安土重迁，乡思颇切，晓岚尤吝于财，虽官游而饮食衣服不遂为愿。至夏忽胸胁大痛，喘嗽不宁，饮食俱减，晓岚来求余治，诊其左脉弦而牢，右寸坚而滑，知为气郁，乃以左金丸合颠倒木金散进二服后，吐痰近数碗，再视之，则左少软，而右亦渐平矣。因以逍遥散加木香、青皮等迭进之，半月后始就平复。（《醉花窗医案》）

【按语】

本案缘由肝郁，遇夏令而横逆犯肺，故从疏肝论治。方以左金丸清肝，木金散（木香、郁金）疏肝，是以药后可收痰涌脉平之效，后以逍遥散疏肝理脾而愈。

讨论和体会：肝与肺具有相克的制约关系，而且在人体气机升降活动中相互为用。因肺为气之主，肝司气之化，肝从左而升，肺从右而降，所以其病理变化多反映出气机升降失调。

肝气犯肺是肝病中较多出现的一个证候，诚如王旭高所云：“肝气上冲于肺，猝得胁痛，暴上气而喘，宜抑肝。”本证又进一步发展，气

逆可化火，火炼津液成痰，痰火壅阻于肺，形成痰火阻肺之证，如症见：发热痰喘，胸中满，身痛，脉弦急，下及厥阴循行之处，则睾丸肿痛，甚则痛不可忍，治宜清肝宣肺，理气化痰，可选叶天士哮喘门治验中所用之方，暂名平肝理气宣肺方：苏子10克，枇杷叶10克，杏仁10克，瓜蒌皮10克，半夏10克，茯苓12克，姜汁1匙，竹沥1匙，郁金10克，旋覆花12克，柴胡10克。该方以苏子、枇杷叶利肺降气，杏仁、瓜蒌皮宣畅气机，半夏、茯苓和胃化痰，竹沥、姜汁达痰通络，妙在郁金、柴胡、旋覆花以疏肝理气。全方在宣通气机的基础上，具有解中焦凝集之痰热，宣上焦如雾之清阳的作用。本证若进一步发展，则出现肝火犯肺，木火刑金之证，我们将在肝郁化火证治中叙述。

值得指出的是，在外感热性病中，由于脏腑相关，也常可出现肝乘肺的病理变化。如《伤寒论》109条云：“伤寒发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，其腹必满，自汗出，小便利，其病欲解，此肝乘肺也，名曰横，刺期门。”期门乃肝经募穴，刺期门以泄肝邪，则肺病自愈；又如《温病条辨》选桂枝柴胡各半汤加吴茱萸、川楝、茴香，云此即“金胜克木也，木病即金病并见，表里齐病”的肺燥肝伤之证，现录《吴鞠通医案》一则，以印证之。

某某胃痛胁痛，或呕酸水，多年不愈。现在六脉弦紧，皆起初感受燥金之气，金来克木，木受病未有不克土者，土受病之由来，则自金始也。此等由外感而延及内伤者，自唐以后无闻矣。议变胃而不受胃变法，即用火以克金也。又久病治络法：云苓、生苡仁、枳实、半夏、川椒炭、生姜、广皮、公丁香。

此症属胃痛、胁痛、呕酸，缘由肺燥肝伤而起，竟用“变胃而不受胃变”之法，议宣降辛散之方，是谓“伏其所主，必先其所因”之治，实求本之图。

五、肝脾失调

肝脾失调是指肝脾两脏功能失去调节平衡引起的一系列症状而言。肝属木，脾属土，木能疏土，若忿怒悒郁伤肝，忧愁思虑则伤脾，肝脾不和，土木气郁，可出现木郁陷土之证；木赖土培，若土虚木乘，可致肝强脾弱；若肝失疏泄，脾失运化，肝脾失调，又可见肝郁脾虚血少之证，证候不同，论治有别，现分述如下。

（一）肝气克脾

症状：胁腹皆胀，四肢无力，饮食不振，食后胀满，大便不成形，脉弦无力，舌淡苔白。

证候分析：肝气犯脾，常见于脾气先虚而后肝乘。本证因脾气先虚而不运，故腹胀食减，四肢无力等症丛生。脉弦主肝病，脉软无力主脾虚，舌淡苔白亦是脾虚之候。

治法：疏肝健脾。

方药：香砂六君子汤。

人参6克，白术9克，炙甘草6克，茯苓9克，半夏10克，生姜10克，陈皮6克，木香3克，砂仁6克。

方义：人参、白术、茯苓、炙甘草补中气之虚，半夏、生姜、陈皮、砂仁、木香调和脾胃之气。

【案例一】

痢疾，年五十，阴气自半，肠中干燥，喜用西法灌肠，而转为下痢，色青如蓝，肛门时时坠胀，历五六日，片刻不能安适。谷食减少，舌中剥，边薄腻，脉虚弦，良由灌肠之时，风邪从肛门而入，风气通于肝，青者肝之色，风淫于肝，肝木乘脾，脾失健运之常，谷食入胃，不能生化精微，而变为败浊。风气从中鼓荡，驱败浊下注大肠，而为下痢

色青蓝也。肛门坠胀者，中虚清气上升，经所谓“中气不足，溲便为之变”也。宜补中益气，去风化浊之治。

清炙黄芪，炒防风，清炙草，银柴胡，炒蜜炙升麻，炒潞党参，全当归，炒白芍，苦桔梗，陈皮。（《清代名医医案精华·丁甘仁医案》）

【案例二】

李右，肝脉挟胃而贯膈，少腹为厥阴部位，肝气侮脾，脾运钝而温热内袭，胸腹胀痛，肢体俱肿，脉沉苔腻，治宜理气渗湿，以和土木。

焦白术，广陈皮，台乌药，大腹皮，川芎，郁金，青皮，苓皮，香附，泽泻，佛手。（《陈良夫医案》）

【按语】

肝气克脾，大都是指脾气先虚，导致肝气来乘，既见脾虚之证，又见肝气横逆之征，重在补土泄木，尤以补土为主，佐以泄木，故多以六君子汤以培土，所谓“肝为木气，全赖土以滋培”，但运用六君子汤补土却有变通。叶天士在《临证指南医案》中，运用六君子汤加柴胡、白芍；王旭高《西溪书屋夜话录》中用六君子汤加吴茱萸、白芍、木香。叶氏是扶土之中佐以疏泄，旭高则佐以酸甘温化。案一中丁氏则重在温建中气，使“中央健，四旁如”，则肝病自愈。但临床运用时仍应注意；①脾虚湿胜，白术不可过用，以防其壅；②禁用苦泄沉降之品，免伤脾气；③把抑木扶土与疏肝理脾法鉴别清楚。

案二亦属肝脾失调。脾失健运而湿浊内停，肢面俱肿，脾弱则肝气侮之，胸腹胀痛。故案中以实脾为先，兼以渗淡利水，疏肝行滞，使脾旺湿去，肝气自调，若不培土以调肝，徒用渗利，便是舍本求末之治。

（二）肝强脾弱

肝病过程中，肝气横逆而克犯脾土，即所谓“实则乘其所胜，或反

悔其所不胜”，与前述的脾虚肝克证治不同。前者以脾虚为主，本证是以肝实为急。

症状：脘腹胀痛，泄泻，痛则欲便，便则痛减，脉弦见之右关。

证候分析：痛泻是本证的一个辨证眼目，《医方考》云：“……泻责之脾，痛责之肝，肝责之实，脾责之虚，脾虚肝郁，故令痛泻。”右关候脾，弦为肝气过强，因肝实克脾，故肝脉见于脾部。

治法：抑木扶土。

方药：痛泻要方。（《刘草窗方》）

陈皮10克，白芍12克，防风10克，白术12克。

方义：方中以白芍酸收平肝缓急，防风辛散疏肝缓脾，陈皮理气和中，三药合用，重在抑肝木之横逆，配白术健脾以扶土，是以有抑木扶土的作用。

【案例】

张某，男，33岁。北京南郊农场。腹泄腹痛月余，经用卡那霉素等西药，理中、保和丸等中药，未见减轻，就诊时见：腹痛胀满，痛则欲泻，泻则稍舒，每日溏便7~8次，便后有黏液，腹部胀满，时反酸，口干不欲饮，舌质红苔黄腻，脉细弦。证属肝实克脾，寒热夹杂，拟抑木培土，寒热平调为法。

白术10克，陈皮10克，白芍10克，防风6克，木香3克，砂仁6克，黄连6克，干姜6克，半夏9克，黄芩3克，焦楂曲各10克。

服药4剂，痛泻减轻大半，续服4剂而愈。

【按语】

肝强脾弱，理宜抑木扶土，但症有兼寒热错杂者，可用寒热平调合法，本案所以取效迅速，理在此也。

（三）肝郁脾虚血少

症状：胸胁胀满，头痛目眩，口燥咽干，食少，妇女月经不调，舌淡而干瘦，脉虚弦。

证候分析：肝失疏泄，则胸胁胀满疼痛；木不疏土，则食少；肝血不足，则口燥咽干；头痛目眩，妇女月经不调，脉虚弦，乃肝脾两虚之象。

治法：疏肝理脾养血。

方药：逍遥散。（《和剂局方》）

甘草15克（炙），当归、茯苓、白芍、白术、柴胡各30克，共为末，每服6~9克，生姜、薄荷少许煎汤冲服，日三次，亦可改为汤剂。

方义：方中以柴胡疏肝，当归、白芍养肝，白术、甘草、茯苓培中，煨姜、薄荷少许同煎，意取舒郁和中。

【案例】

脾虚肝郁：先生之弟妇，患头痛发呕，饮食不思，时瘟疫行，疑为时症。余偶到此，其往兰芬兄言其状，并邀之治。问曾患身觉憎寒壮热乎？曰：否。问身痛鼻塞乎？曰：否。然则非时症。诊其脉，则左关弦滑，余俱细弱，告兰芬曰：脾虚肝郁也，作时证治，必散之，虚而散，则大误矣。兰芬请一方，因以逍遥散进，余过而忘之，越数日，见兰芬，告余曰：药才二服，病全除矣。（《醉花窗医案》）

【按语】

脾虚肝郁血少，运用逍遥散是为正治，但要指出的是，运用时首先应理解其适应证，姑录秦伯未的一段话，以供参考。秦老说：“如果肝旺而用归、芍、柴胡，势必助长气火，脾受克制再用术、草、茯苓也会更使壅滞。必须明辨虚实，才能理解本证的寒热往来不同于少阳证，头痛胁胀不同于肝气横逆，饮食呆滞也不同于胃家实满。”（《谦斋医学讲稿》）其次，对于肝阴已伤的患者，不可执逍遥散为定法，宜增损变通。其三，逍遥散辨证定位应在肝脾失调，且兼血少之征，对于肝郁初起，本脏本经自病，其效始不如四逆散疏达轻扬为快，开降得体，这在临床上都是应与明辨的。

《素问·玉机真脏论》云：“肝痹……弗治，肝传之脾，病名曰脾风发瘵，腹中热，烦心出黄。”这里所指的“脾风发瘵”，即是肝木横逆克脾，无疑是肝实克脾；《素问·气交变大论》云：“飧泄食减，体重烦冤，肠鸣腹支满……甚则忽忽善怒，眩冒巅疾。”这里所指的“眩冒巅疾”，显系原发于脾而使肝气横逆，以脾虚为主。由此可见，必须辨清肝气克脾与脾虚肝克之证。

六、肝气乘胃

肝足厥阴经脉“挟胃”，胃为阳明燥土，其经别“合诸经之气”，肝与胃虽是一脏一腑，但在肝病过程中，肝气犯胃尤为多见，可谓“肝胃之气，本又相通，一脏不和，则两脏皆病”。所表现的证候有：

（一）肝气犯胃

症状：脘腹胀痛，呕吐酸水，嘈杂不适，脉弦滑，舌边尖红，舌苔白腻。

证候分析：肝胃不和，由肝气不舒所致。脘腹胀满，为肝郁而胃不和；呕吐酸水，嘈杂不适，是肝之郁火逆于胃中，舌边尖红，反映肝有热；苔白腻主胃有痰湿。

治法：疏肝和胃。

方药：萸连二陈汤。

吴茱萸9克，黄连9克，川楝子6克，陈皮9克，半夏9克，茯苓10克，生姜9克，香附9克。

方义：吴茱萸配黄连名左金丸，能治肝经火郁，呕吐酸苦；川楝子、香附疏肝理气；半夏、陈皮、生姜、茯苓和胃化痰。

【案例】

肝胃气痛，痛久则气血瘀凝，曾经吐血，是阳明胃络之血，因郁热蒸迫而上也。血止之后，痛势仍作，每发于午后，诊脉小紧数，舌红无苔，乃血去阴伤，气分之邪热，仍阻于肝胃之络，而不能透达。宜理气疏郁，取辛通而不耗液者也。川楝子、元胡、郁金、香附、茯苓、陈皮、旋覆花、山栀子、白螺蛳壳，左金丸。（《清代名医医案精华·王旭高医案》）

【按语】

阴伤而又血瘀，气滞而又郁热，两关肝胃，取辛通而不耗液之品，意在理气舒郁以调和肝胃，使阴复气通而病愈。

（二）肝气犯胃阻隔

症状：脘痛，上下格拒，恶心干呕，脘痞不食，吐酸水涎沫，脉右弱左弦。

证候分析：肝气横逆犯胃阻隔，上下不得通畅，故脘痛格阻；气逆冲上，胃失和降，故呕吐恶心、吐酸水涎沫；胃降不能，则脘痞不食。脉右弱左弦，为肝强胃弱之征。

治法：制肝安胃。

方药：制肝安胃汤。

川黄连5克，川楝子12克，川椒4克，白芍12克，乌梅15克，淡姜渣12克，当归须12克，橘红10克。

方义：方中以乌梅、白芍味酸以和肝之体；川楝子、姜渣、川椒、橘红以调肝之用；当归须入血分以治络；黄连入胃以降气逆。戴元礼说：“诸寒药皆凝^渣，惟黄连不凝^渣，《内经》苦与辛合，能降能通，芍药酸寒能泄土中木乘，又能和阴止痛；当归血中气药，辛温上升，用须力弱，其气不升；梅占先春，花发最早，得少阳之气，非酸敛之收药，得连楝苦寒，《内经》所谓辛苦泄热也。以气与热，俱无形质，其通逐之法迥异。

【案例】

郭某，脉弦，心中热，欲呕不思食，大便不爽，乃厥阴肝阳顺乘胃口，阳明脉络不宣，身体掣痛。当两和其阳，酸苦泄热，少佐微辛：川楝、桂枝木、生牡蛎、乌梅、生白芍、川连。（《临证指南医案·木乘土》）

【按语】

华岫云说：“胃主纳食，职司通降，其所以不降而上逆呕吐者，多由肝气冲逆，阻胃之降而然也。”肝气犯胃，若证偏轻的多为初起，治在苦辛通降之中，佐以和胃化痰；若肝气犯胃而其证偏重者，治宜酸苦泄热之中寓辛散为妙，因气与热阻，不得交通，唯酸能敛，唯苦能降，唯辛能散，是以酸收、苦降、辛开为一炉同治。此实仿《伤寒论》乌梅丸制方之旨，所不同的是大论的乌梅丸，用于肝木贼犯胃土，虽证见寒热错杂，而以阳虚为先，与本证以热为主有别。

（三）胃虚肝乘

肝气犯胃，临床固不少见，但胃虚招致肝气横逆犯胃，亦常有之，其症状表现为：纳差，神疲，或心烦不寐，口干便结，脉弦缓等证。

证候分析：胃为水谷之海，后天之本，胃虚则津液不足，纳降失司，是以纳差神疲。肝虚则疏泄不及，魂不得敛，故心烦而不寐。至于口干便结，脉弦缓，皆为肝胃气阴两虚之象。

治法：缓肝益胃。

方药：缓肝益胃汤。

炙甘草10克，南枣10克，人参10克，茯苓12克，木瓜10克，生谷芽15克。

方义：胃虚不固，仓廩已虚，欲治肝病须健阳明，方中以甘草、大枣甘缓守中，佐木瓜以敛阴生津，合为酸甘化阴之法。参、苓、谷芽助脾胃之气，取其谷气悦胃醒脾，使脾胃得养，肝得其滋，而诸症可愈。

【案例一】

唐某，女，68岁。老人中气虚衰，纳食不馨，而口干便秘，懒于活动。最近与孙媳生气，精神更感疲惫，水米不思，厌世不起。切其脉弦缓无力，舌苔白而质则淡，此乃脾胃两虚，木气又横之象。用缓肝益胃汤，另加钩藤、蒺藜，服十数剂，则胃开能食，诸证悉蠲。

【案例二】

某女，胃气以下行为顺，肝气以横逆为客。湿热痰沫，阻遏中宫，则胃失降而肝木乘侮，脘腹痞闷，噎恶频频，脉弦细，苔糙干，治宜和中泄木。

藿梗，左金丸，法半夏，广郁金，石决明，橘红，金铃子，山栀，姜竹茹，佩兰叶。

二诊：气与火皆从厥阴来，上冲咽道者，都是火。进和降法，噎恶已止而咽干，痰黏不豁，脉细数、苔糙，中宫之湿热渐化，木火之主盛未平，宜清降之。

左金丸，山栀子，郁金，黄芩，川楝子，半夏，蛤壳，杏仁，石决明，竹茹，黛灯芯。（《陈良夫医案》）

【按语】

上述两案，都属肝气犯胃，但前者为虚，胃虚招致肝木来克，故缓肝益胃为法，后者为肝实乘胃，致湿热痰浊肝火诸邪夹杂为患。故首以化湿浊、辛平苦降，佐以疏肝理气，继则增黛蛤、黄芩降火之力，始终用平肝之石决明，以防肝热导致肝火燔灼，是以取效均好。由此可见，辨治肝胃不和，应注意虚实证治有别。

讨论和体会：肝气犯胃，也称肝胃不和，不仅在肝炎病中可以见到，而在杂病中亦易出现。因此，把握肝胃不和的病理变化和证治规律很有必要。

肝胃不和的病理特点是：①肝为乙木，胃为阳土，土受木克，则肝为起病之源，而胃为传病之所。正如叶天士所说：“厥阴之气上干，阳明之气失降……肝藏厥气，乘胃入膈。”（《临证指南医案》）②肝为生化之脏，胃为十二经之海，皆寓冲和的生阳之气，关系着后天化源之本，且肝阳之戢敛，肝血之生成仰赖胃中津液，若肝胃失调，则化源困乏，就会出现肝胃不和等证。

肝胃不和的临床表现比较复杂，归纳起来可有：①吞酸吐酸。顾松园说：“吞酸吐酸之病，是胃中湿热，郁遏肝火所致。”②胃脘疼痛。《素问·六元正纪大论》说：“木郁之发，民病胃脘当心而痛。”③呕

吐。肝火冲逆，或肝寒犯胃，使胃气上逆时皆可见之。

肝胃不和，治应遵循“泄厥阴以舒其用，和阳明以降其气”的原则。具体而言，仍有主次缓急不同：①以厥阴肝为主，治宜酸苦泄热，少佐微辛；②以阳明胃为主，治宜扶胃为急，如胃虚不固，络脉已空，重在“固阳明”，甚则治肝不应，当独取阳明为治，因胃以通为补，胃壮则肝自不犯；③若厥阴阳明同病，或“通补阳明，和厥阴法”，或“理阳明，制厥阴法”，皆应随证治之。

七、肝气及肾

肝肾同源，不仅说明精血相生，而且也说明阳气互用，在生理上关系密切。在病理状态下，若肝气有余，也可下伤及肾。

（一）肝气及肾，肾阳衰微

症状：胸胁胀满疼痛，连及腰脊酸楚，肢体不温，精神疲乏，头晕失眠，阳痿早泄，或见浮肿。

证候分析：肝主疏泄，藏血之脏，失其疏泄，则胸胁胀满疼痛；肝气及肾，故连及腰脊酸楚。肾主闭藏，藏精不泄者也。今肾气虚衰，故肢体不温而阳痿早泄。若肝肾精血同损，则精神萎靡，头晕失眠，甚则浮肿。

治法：疏肝滋肾。

方药：逍遥二仙汤。

白芍10克，当归10克，白术10克，甘草6克，柴胡6克，茯苓10克，仙茅10克，仙灵脾10克，肉苁蓉10克，菟丝子10克，黄柏3克。

方义：方中以逍遥散疏肝养血，仙茅、仙灵脾、肉苁蓉、菟丝子温补肾之阴阳，反佐黄柏以坚阴气之蛰藏。

【案例】

姚某，男性，32岁，婚已年余，患阳痿8个月，曾用温肾滋肾等法不效。起病前，肝气抑郁不舒，阳痿不举，或举而不坚，时有滑泄梦遗，近更感腰酸疼痛，头昏神疲，胁腹胀满，并有纳差，肢冷，舌苔薄黄，质淡，脉沉弦而数等证，诊为肝郁脾虚，肾阳不充之证。拟用上方平补平调，首服二十剂，诸症悉除，以原方合五子衍宗丸蜜丸配伍巩固，后生一女。

【按语】

阳痿一般多责阳虚，殊不知阴器系宗筋所聚之处，厥阴经脉分属之部，因精神抑郁而患阳痿者，亦复不少。本证肝郁及肾，肾阳衰微，故肝肾同治，而诸症悉愈。

（二）肝气及肾，肾阴不足

症状：胁痛，吞酸口苦，疝瘕，舌红少津，脉来虚弦。

证候分析：阴虚易致气滞，血虚则络伤，肝气逆郁，是以胁痛、疝瘕，犯胃则吞酸口苦，舌红少津、脉虚弦是肝郁及肾，肾阴不足之征。

治法：养阴疏肝。

方药：一贯煎（《柳州医话》）加味。

沙参、麦冬、当归各12克，生地30克，枸杞6克，川楝子10克，柴胡6克，白芍10克。

加减法：大便秘结加瓜蒌仁；虚热汗多加地骨皮；痰多加贝母；舌红而干，阴亏过甚加石斛；胁痛而胀，按之痞坚者加鳖甲、牡蛎；烦热而渴者加知母、花粉。

方义：方中以生地滋养阴血，沙参、麦冬养胃生津，枸杞补肾，白芍护肝，三脏同补之中，妙用川楝子调肝木之横逆，柴胡疏肝气，当归养血液，从而使肝体得养，肝用能舒，阴阳体用得平衡。

【案例】

乔某之子名夏清.....春来乍得胀疾，两目痛楚，夜则尤甚，易数医，无少效。因忆前治家君之病，甚有确见，故特来请治。余拨其眶视之，则黑珠周围起白膜，带二三红血点，诊其脉，则左关弦滑，尺微细。乃曰：此阴虚肝郁也。幸未久，尚无害。若再迟数月，则生外障，翳膜遮睛，则揭去非易。乃先开一疏肝散，又继用杞菊地黄汤，二方并付之。告知曰：先服疏肝散三四剂，痛当止，继用地黄汤不十剂，当无事矣.....半月后，忽自称谢，目疾痊愈。（《醉花窗医案·阴虚肝郁双目痛楚》）

【按语】

阴虚肝郁，阴虚是本，气滞是标，肝气之所以滞，乃液之不能充，肝阴愈虚，肝气则愈滞，因“血即从气，其体静而不动”（《此事难知》），多一分阴虚，便增加一分气滞，因此滋阴治其本，理气治其标，标本兼顾。此时若徒用香燥，更灼阴血，徒于养阴，肝气愈横而逆，必须“疏肝”、“柔肝”相结合，柔肝重在滋养肾阴，水足则木柔，疏肝只能暂用，中病即止。若肝本身阴虚而气滞，表现为肋下疼痛固定不移，咳痰不爽，纳差食减，五心烦热，舌紫，胁弦长，可用滋阴调气通络法，选方用《重订通俗伤寒论》新加酒沥汤：当归、生地、白芍、柴胡、甘草、陈皮、薄荷、竹沥、陈绍酒。该方用四物汤去川芎以养阴活血，四逆散去枳壳宣展气机，陈皮和胃，薄荷解郁，妙用竹沥、陈绍酒辛散通络，从而滋阴与调气并行不悖。

八、肝气迫及冲任

冲任有血室之称，上属阳明胃腑，下隶厥阴肝脏，若肝气有余及冲，则冲阳不潜。任脉隶属于肾，主精室与胞宫，肾虚则任阴不固，任阴不固，则肝气易于下迫任脉，是以肝气有余可迫及冲脉，下伤任脉。

（一）冲气上逆

症状：心中痛热，咳逆，呃逆，甚则晕厥，舌红苔薄黄，脉弦数。

证候分析：冲脉有血室之称，其血液来源为后天胃化水谷，经中焦取汁变化而赤后，由肝络下注冲脉。若肝失疏泄，气血失调，化风上冲，则冲气上逆而冲心，故心中疼热，冲肺则咳逆，冲胃则呃逆，严重时上冲头目，故晕厥。舌红苔薄黄，脉弦数，系冲气上逆，肝阴不足之象。

治法：清肝镇冲。

方药：新加玉女煎。（《通俗伤寒论》）

生石膏30克，知母10克，麦冬10克，熟地15克，牛膝10克，紫石英10克，磁石12克，白薇12克，石决明15克，青皮10克。

方义：方中以生石膏、知母、麦冬清阳明胃热以镇冲，牛膝引血下行，熟地滋补肝肾之阴，紫石英、磁石、石决明潜阳镇逆纳冲，白薇清浮游之虚热，而有清热镇冲之效。

（二）冲任失调

症状：疝瘕，气逆上冲，少腹肿块，妇女月经不调，流产或不孕，舌绛苔净，脉细数。

证候分析：肾阴不足，虚火时炎，水不涵木，则肝气亢盛，迫及任脉，则冲阳不潜与任阴不固同时存在，冲阳不潜，故气逆上冲；肝气不疏，气血凝涩则病疝瘕，少腹肿块；任阴不固于下则流产、不孕；妇女

月经不调，舌绛苔净，脉细数，为肝气下伤冲任之征。

治法：平肝，调冲固任。

方药：调冲益任汤。（《通俗伤寒论》）

龟板20克（先煎），熟地15克，知母9克，黄柏3克，砂仁 6克，炙甘草6克，白果6克，乌贼骨10克，茜草10克。

方义：方中以大补阴丸滋阴泻火，《删补名医方论》云：“是方能骤补真阴，承泻虚火，较之六味功效尤捷。”配用封髓丹清肾火之妄动，以达调冲之效；配四乌贼骨一**蒺**茹丸敛精活血，与白果固摄冲任而同功，故本方以平肝调冲固任为长。

综上所述，肝气冲逆之症，多由肝脏本经开始，易在气分流连，或气逆本脏，或气火内郁。若其发展变化，或化火动风生痰而变证蜂起，或干犯他脏而百病丛生。但值得特别提出的是，五脏是一个整体，一脏有病则影响他脏，不过对肝脏来讲，因其有“脏首”之称，故为害尤多。因肝体阴而用阳，关系气血水火，这些生理的特殊性决定了它在五脏动态平衡调节中的地位，比如维持心肾相交，水火既济的动态平衡，需要肝木疏泄以交通。因肾为水脏，能生养肝木，木赖水涵，心为火脏，火赖木生，故肝木有养心之功。由此可见，肝正处于心火肾水的中间，所以肾水之上滋，心火之下降，非皆中焦之斡旋，其中应看到，肝疏泄气血，交通阴阳以为水火之枢纽，方使心肝肾一气贯通，以维系动态平衡。所以肝病之后，也可以使心肾的交通发生障碍。由此可见，研究肝气冲逆的证治规律，要注意权衡脏腑之间平衡失调的病理变化，才能把握其规律，而收到较好的辨证论治效果。

第三章 肝火证治

肝火是肝脏病理变化之一，其表现的症状在肝病变化中也是错综复杂的。凡是肝脏机能亢进，出现热性及冲逆诸病症，概称为“肝火”。

由于肝体阴用阳，藏阴贮血，而内寄相火。这种相火，在正常生理状态下，是人生不可缺少的“少火”，“少火生气”，能推动机体脏腑功能活动。在病理状态下，相火处于既伤且抑的地位，或由伤转复，以不可阻挡的势力暴发出来，此即所谓“郁极乃发”，或者由“三因”致病而引起机体内阴阳、脏腑、气血失调，并进而使相火冲激，给机体以破坏。“壮火食气”、“壮火散气”即是指这种邪火而言。因此，区别肝火中生理上的“少火”和病理上的“壮火”，是很有必要的。

肝为五脏之一，有“脏首”之称，其生理功能的重要和复杂，为他脏所不及。其病理变化也较他脏错综复杂，尤其是肝火之为病，其害甚大，其变甚速，其势甚彰，其死甚暴，故前人有“肝为万病之贼”之说。可见探讨肝火的证治规律，是尤为必要的。

形成肝火的病因病理，虽然错综复杂，但仍可归纳为三个主要方面：

1.气郁化火 肝为刚脏，内寄相火，条达时则顺其生生不息之机，抑郁时则郁，郁极乃发，由少火而变成壮火，从而形成肝火。叶天士说：“情志不适，郁则少火变壮。”（《临证指南医案·郁》）《谢映庐医案》亦说：“寡居多郁，郁则少火变成壮火。”由此可见，气郁化火是肝火形成的一个病理环节，起于情志抑郁或嗔怒太过，病于肝胆相火由少变壮，郁极则变化而生。

2.亢阳化火 亢阳是指肝阳亢。肝体阴用阳，肝之阴阳总是处在相对平衡状态下，维持其生理。若阴阳失其平衡，肝阳偏亢，浮动于上，便易化火而形成肝火，张志聪说：“阳亢则火壮。”另一方面其化火过程也与肝胆内寄相火有关，相火失其潜藏，阳气升腾，龙相上逆，便成肝火。唐容川说：“肝为藏血之脏，又司相火，血足则火温而不烈，游行三焦，达于腠理，莫不得其温养之功。若血虚火旺，内则烦渴淋闭，外则骨蒸汗出，皆肝经相火之为病也。”（《血证论》）

3.湿热化火 湿热时邪，内侵肝胆，蕴结不解，湿蕴化热，热从火化，易形成肝火。或肝胆气机郁滞，湿热成毒，蕴而为火。诚如柯琴说：“厥阴之地，相火游行之区也，其本气则为少火。若风寒燥湿，一入其境，悉化为热，即为壮火。”（《伤寒论翼》）

上述诸因，皆以肝气有余（即太过为病理基础，即前人所谓“气有余便是火”）。气化于火，由郁而生，可出现诸种肝火病证。病证虽多又繁，但理解火邪为病的特点，便能把握其规律。诸如，火为热极，易燔灼一身上下内外；火性炎上，易见头面五窍诸证；火性易动，可致他脏为患；火与阴气不两立，易耗气伤阴动血。了解这些特点，结合肝脏特性，无论怎样复杂的兼证、合并证，便易遁情矣。

肝火的主证以目赤面红，头晕胀痛，急躁易怒，舌红苔黄，脉弦数等为常见证。肝火与肝热有轻重不同的差别，热轻火重，肝热无冲激上逆之象，肝火则必见冲逆燔灼之证，较热欲化而未化火的“气火内郁”为重。肝火冲逆无制，影响他脏，往往出现更多病证。所以《类证治裁》说：“木郁则化火，为吞酸胁痛，为狂，为痿，为厥，为痞，为呃噎，为失血，皆肝火冲激也。”很明显，这些病证既可以是肝火直接产生，也可因肝火冲激他脏所致，因此，对肝火的辨证，还要辨清病位之不同。

治疗肝火的原则，一般采用苦寒直折，所谓“热者寒之”。除苦寒直折之外，还应配伍其他方法，以适应变化多端的肝火病证。常见的配伍方法有：①配辛散。根据《素问·六元正纪大论》“火郁发之”的原则，可于苦寒直折的基础上，佐以升散，寓升于降，升降同用，以治疗肝火郁遏于内或郁遏于上，火郁不得发泄的病证。②配疏肝。根据《素问·脏气法时论》“肝欲散，急食辛以散之”的原则和火郁极乃发的病机，可清泻肝火与疏肝理气配伍同施，用治肝火燔灼而又见气郁气滞之证。③配养肝。肝肾精血同源，阴虚则阳亢，阳亢则化火，火盛又伤阴血，故可于清肝泄热之中配伍养肝滋阴之法，龙胆泻肝汤中配伍当归、生地，意即此意。④配清金。肝火旺盛反侮肺金，可清泻肝火与泻肺同施。⑤配泻心。心为火之主，肝为火之母，心火内亢可引动肝火，肝火过旺可致心火炽盛，故清肝之中配伍泻心火之剂，或谓实则泻其子之义。⑥配补气。火能耗气，又能侵犯脾胃中焦，以致脾胃虚弱，可清肝与补气同施。⑦配重镇。肝火上炎诸证，除以苦寒直折外，皆可配伍石决明、代赭石、磁石等品以镇肝。

要之，实火宜泻，虚火宜养，补虚泻实为治肝火大法，为了便于临床掌握起见，本章重点讨论肝火实证的证治规律，对于肝火虚证，我们将在下面肝火伤阴、肝虚证治等有关章节中讨论。

一、肝火上炎清窍

症状：头痛，目赤或痛，颊赤，心烦，急躁易怒，口苦，或耳中作痛，脉弦而数，舌边尖红绛。

证候分析：火性炎上，上炎则气火俱升，直犯至高之巅，故头痛；清窍受蒙，故目赤或痛，颊赤，耳中作痛；心烦，急躁易怒，皆肝火燔灼之证。口苦为火迫胆汁之象，故肝胆火郁，则口苦尤甚。脉弦而数，舌边尖红绛，皆肝火所致。

治法：轻清凉泄。

方药：清肝泄火汤。

丹皮12克，桑叶10克，山栀子12克，白芍12克，荷叶6克，钩藤12克，夏枯草15克，生地12克，菊花12克。

加减法：不寐，加半夏、秫米；颈项结核加川贝、牡蛎；口苦溲黄加龙胆草。

方义：方中以桑叶、菊花、钩藤、荷叶轻清辛寒宣散于上，以散上炎之火，叶天士说：“辛寒清上，头目可清。”以夏枯草清泻肝火，栀子治火郁之烦，丹皮凉血，三药皆苦寒，可直抑火炎之势。佐以生地、白芍凉血养阴护肝，意在安未受邪之地。

【案例】

史某，男，22岁，患癫痫病，每月发作两次，作时人事不知，手足抽搐，头痛目赤，喉中痰鸣。切其脉沉弦滑数，视其舌苔黄而质绛。辨证：肝火动风、动痰，上扰心宫，发为癫痫。脉弦主肝病，滑数为痰热，而舌苔黄故知其然也。法当凉肝熄风，兼化痰热为法。处方：桑叶10克，菊花10克，丹皮10克，白芍30克，钩藤10克，夏枯草10克，栀子10克，胆草10克，生地10克，生石决明30克，甘草6克，竹茹12克，黛蛤散10克，玄参12克。

服药后颓然倒卧，鼾声大作，沉睡两日，其病竟瘥。

【按语】

热盛生风，火盛生痰，风乘火势，火借风威，熄风重在凉肝，治痰之法清其火。本案肝火是主要矛盾，继则动风、动痰，而上扰心宫，故凉肝以熄风，清火以化痰热，竟取效如响，且凉润之中，寓养肝阴于其中，尤为稳妥。

二、肝火内扰胸脘

症状：纳食脘中噎塞，口苦泛恶，烦躁懊恼，脉弦。

证候分析：肝火内扰胸脘，虽能纳食，但脘中噎塞，肝火逆而不能宣达，是以口苦。烦躁懊恼，木火犯胃，是以泛恶，脉弦为肝火内扰之征。

治法：宣泄肝火。

方药：加减栀子豉汤。

山栀子12克，香豆豉10克，川楝子10克，橘叶10克，竹茹10克，芦根15克。

加减法：脘中窒痛，呕涎，加瓜蒌皮、贝母；咳逆而便不爽者，加杏仁、枇杷叶；若胸中发满，气机不畅的，加白寇、枳壳。

方义：方中以栀子苦以泄热，寒以胜热；以豆豉轻清上行，化浊宣清，宣透解郁，此仿《伤寒论》栀子豉汤法，以泄热除烦。加川楝以舒肝胆之热，配橘叶舒理肝气而不助燥，加竹茹清胃化痰止呕，芦根清肺胃之热以解毒，务使痰热解除，气机舒展，则肝火自平。

【案例】

张某，男，57岁。纳谷则脘中哽噎，自述因情志抑郁以酒浇愁，使木火犯胃，胃气失于和降，故脉弦而舌苔黄腻。拟苦辛泄降法：黄连、郁金、淡豆豉、竹茹、陈皮、丹皮、生姜。（《临证指南医案·木乘土门》）

【按语】

肝火内扰胸脘，凉泄是为正治，仍不失“火郁发之”之旨。叶氏大法不变，而用药灵活，常用栀子豉汤，佐以微辛宣通，微苦清降，可用治外感热病的风湿、湿温、暑温以及内伤之胃痛、痞证、呕吐、眩晕、吐血等证，实可谓善用经方，变化而不失原则，可为后世效法。

三、肝火扰魂

症状：惊狂初起，不寐神呆，时发惊狂叫喊，不食，不饥，不便，或癎厥肢强，或热蒙头巅，神识如蒙。舌红苔黄腻，脉弦大而数。

证候分析：肝在志为怒。因暴怒惊恐，阳气上逆，相火扰及肝魂，肝魂不宁，故不寐、神呆、不食、不饥、不便，甚则癎厥，神识为蒙；动风则肢强。舌红苔黄，脉弦大而数，皆肝火之征。

治法：凉肝清火，戢敛肝魂。

方药：加减当归芦荟丸。

羚羊粉1克（分冲），山栀子12克，大生地15克，龙胆草15克，芦荟12克，木通10克，丹参15克，青黛10克，薄荷6克。

方义：方以羚羊粉、胆草、芦荟、青黛以凉肝泻火，山栀、木通导火下行，生地滋肾水，丹参养心阴而活血，妙在薄荷轻散上达，又免诸药苦寒留滞，全方苦寒直折以清肝火，滋阴壮水以制阳光，以辛散透达发越火郁，以通泄州都，而导热下行。

【案例】

叶某，29岁，五志阳升，神志迷惑，忽轻忽甚者，非有形质之邪，乃热气化风上巅，致于竟夜不寐，攻痰疏利，决不效验，先以极苦之药，冀其亢阳潜降。生地、龙胆草、丹参、木通、山栀子、芦荟、青黛、薄荷。（《临证指南医案·肝火》）

【按语】

“攻痰疏利，决不效验”一语，对于肝火扰魂，为辨治眼目。本案因肝火燔灼，肝魂不藏，自宜禁用攻痰疏利之药，以免伤阴而使肝火愈炽，致病变化而莫测。

应当指出，运用加减当归芦荟丸时，应与张锡纯安魂汤及《伤寒论》柴胡加龙骨牡蛎汤相鉴别。安魂汤适用肝魂不藏而兼有痰饮停心之证，故方中用半夏、茯苓清利痰饮，龙、牡安魂定魄，赭石体重以镇肝，龙眼肉甘温而补心血，枣仁敛心肝之阴气，共成心肝同治之法。至于柴胡加龙骨牡蛎汤，乃适用于少阳枢机不利，邪热内陷，而使肝胆之神气不宁，气化失司，以致胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧之证。意在以柴胡和解少阳之邪，龙骨、牡蛎、铅丹镇肝安魂，大黄泻内结之热，茯苓利三焦之水，务使内外杂沓之邪得以尽解，肝胆之气得以舒顺，则病可愈。三方主治不同，各有所专，亦不难鉴别。

四、肝火充斥三焦

肝藏相火，三焦为相火宣布之道，在肝病过程中，若相火不戢，肝火内盛，则可游行于三焦，使三焦之火发作焚烧而有燎原之势。

症状：胁满，口苦，目赤，耳聋，耳肿，或小便淋浊，阴肿，阴痒，妇女带下等证。

证候分析：肝火内盛，燔灼三焦，在上则目赤口苦，耳聋耳肿；在中则胁痛；在下则小便淋浊，阴肿阴痒。若与湿热相伍而下注，在妇人则带下，在男子则阴茎灼痛而小便不利。

治法：苦寒直折。

方药：龙胆泻肝汤。

龙胆草、柴胡各9克，泽泻12克，车前子9克，木通6克，生地6克，当归尾9克，炒栀子9克，黄芩9克，甘草6克。

方义：本方能清泻肝经之火与湿热下注等证，具有清上彻下之功。故能上清头面五官清窍，下泻膀胱前阴诸疾。以龙胆草泻肝经之火，以柴胡为肝使，以甘草缓肝急，佐以芩、栀、通、泽、车前等药，义在导火下行与湿热之邪从前阴而出。然皆泻肝之品，故又加当归、生地补血以养肝，盖肝为藏血之脏，补血所以养肝，妙在清肝之剂，反佐养肝之药，寓有战胜扶绥之义。

【案例】

姜某，男，30岁。右足大趾外侧突然红肿疼痛难忍，经西医治疗一周，病情未见好转。脉弦滑数，舌苔厚腻。自诉小溲黄短不畅，口苦为甚。余视其肿毒，正当大趾之端毛际丛处，而厥阴肝经起于此，斯乃肝经湿热下注之证。姜问病何名？余曰：此足趾发也。治当清肝经湿热之毒。疏方：龙胆草10克，黄芩10克，柴胡12克，当归10克，生地10克，丹皮10克，白芍10克，木通10克，泽泻10克，车前子10克，蒲公英 12克，紫地丁12克。

服三剂而肿消，又服二剂而能下地步行，后配合“红外线”治疗而

愈。

五、肝火犯肺

症状：干咳少痰，咯血，面红胁痛，呼吸急促，脉弦细数。

证候分析：肝气太过，化火犯肺，以致肺失清肃之令，故干咳少痰，甚则咯血；肝火盛而气滞肝络，故面红胁痛；肺主呼吸，肺气被肝火所燔，故呼吸急促。脉弦细而数，乃肝火盛而肺阴伤之症。

治法：清金制木。

方药：清金制木汤。

沙参12克，麦冬12克，石斛15克，枇杷叶10克，天冬10克，玉竹10克，石决明15克，丹皮12克，栀子12克，生石膏30克，黛蛤散16克。

方义：方中以天冬、麦冬、玉竹、沙参、杷叶、生石膏甘寒清润肺金；以丹皮、栀子、石决明、黛蛤散平肝火之淫威，使金清火伏，而诸症可平。

【案例】

方某，女，39岁。北京地铁职工家属。患支气管扩张十年，屡治乏效，每至春争之日，咯血频频，量多色红，吐痰黄稠，口不渴，时胸痛胁痛，动则短气，情绪激动则易发，纳食、睡眠、二便均可，颜面憔悴，舌质暗淡，苔净，脉弦细数，证属肝火犯肺。治以清金治木法。方药：青黛6克，蛤粉6克，花蕊石12克，鹅管石12克，侧柏炭10克，芦根20克，苡仁30克，冬瓜仁20克，桃仁6克，红花6克，川贝6克，马勃6克。

守方增损，或佐清化痰热，或佐益气养阴，或佐健脾益肾，经治半年，诸症平稳，次年春竟未复发。

【按语】

古人云：“肺如钟，撞则鸣。”肝火上炎，犯肺而咳，肝火灼而肺阴伤，则津液难以润养肺金，唐容川说：“金不制木则肝火旺，火盛刑金则蒸热喘咳，吐血癆瘵并作。”本案即重在清金制木，佐以清热化痰，是以获效。临床对肝火不重而肺火尤甚者，亦可用泻白散加青黛、胆草、黄芩、柴胡等药，以泻肺清肝。

六、肝火扰心

症状：心烦不寐，口苦，舌糜，小便色赤，舌红，脉弦数。

证候分析：肝火扰心，心主神志，故心烦不寐；舌为心窍，心热上犯，故舌糜红赤。肝胆郁热故口苦，脉弦数为肝火内盛之征。

治法：清心泻肝。

方药：黄连导赤汤加味。

黄连6克，栀子6克，丹皮10克，生地10克，竹叶10克，甘草 10克，木通10克，白芍10克。

方义：用黄连导赤汤泻心火与小肠之火，丹皮、白芍凉血平肝，此乃实则泻其子之法。

【案例】

黎某，女，28岁。心烦少寐，口舌生疮，小便红赤不利，尿道有灼热之感。脉数，舌红苔薄黄。辨为：心与小肠脏腑皆热，而阴分复虚之证。方用：黄连10克，木通 10克，生地12克，生甘草6克，竹叶10克，麦冬12克，石斛15克。共服5剂，诸证悉蠲，小便通利如初。

【按语】

脏腑相关，脏有病传相表里之腑者，临床尤为多见。本案系心移热于小肠，故以黄连导赤散泻心与小肠之火，因火热伤阴，阴亏兼见，故加麦冬、石斛清心养阴为佐，是以药后效捷。

七、肝火伤脾

肝为五脏之首，其为病必犯脾土，是侮其所胜。若肝火燔灼横肆，亦可伤脾，王孟英说：“肝木横肆，脾气伤残，土败而色外越之黄痿。”（《温热经纬》）

症状：泄泻，或热痢下重，大便色青，腿疼掀肿，小儿惊泻等。

证候分析：肝郁化火，火燔肆逆，脾土贼伤，故泄泻或热痢下重；青为肝之色，火为亢逆之邪，故大便色青，而腿疼掀肿；肝主惊，泄泻乃为脾病，故小儿易见惊泻等症。

治法：清肝扶脾。

方药：清肝扶脾饮。

山梔10克，黄柏10克，川楝10克，龙胆草10克，钩藤10克，通草9克，苡仁15克，晚蚕沙10克，车前子9克。

方义：方中以川楝、胆草、山梔、黄柏以清泻肝胆三焦之火，苡仁、车前子扶脾驱湿，蚕沙化浊，钩藤平肝，共奏清肝扶脾之效。

【案例】

马翠庭^{步差}尹令宠，患两腿疼肿，便溏不渴，医进苍术、木瓜、萆薢、独活等药，其病日甚，不食不眠，筋掣欲厥，孟英切其脉，脉弦数而滑，询其热极如沸，曰非寒湿也，肝火为患耳，便溏是土受木乘，不渴乃内有伏痰。予梔、柏、芩、连、茹、楝、通草、半夏、香砂、丝瓜络为方，一剂知，二剂已。（《王氏医案》卷三）

【按语】

本案系肝火而兼脾湿之证。疼肿、脉数，是肝火之征；便溏、口不渴、脉滑，是伏痰以致；痰为脾病属标证，火为肝病属本证。故王孟英

独具慧眼，以泻火化痰，通络止痛为治，故获“一剂知，二剂已”的效果。

八、肝火灼肾

肝肾为母子之脏，肝火下迫，劫灼伤肾，为子病及母。

症状：血与溺俱下，痛不可忍，心神烦乱，目赤口干，舌红苔黄，脉弦数。

证候分析：本证多见于血淋病中，因肝火下迫，动血伤肾，肾失闭藏，血热络伤，故血与溺俱下而痛不可忍；肝魂不宁，故心神烦乱；目赤口干，舌红苔黄，脉弦数，皆肝火之征。

治法：清肝滋肾。

方药：清肝滋肾汤。

川楝子12克，川连6克，龙胆草9克，知母9克，黄柏9克，龟板15克（包煎），鲜生地15克，莲子心10克，金钱草30克。

方义：方中以大补阴丸滋阴泻肾火，川楝、胆草泻肝火，川连、莲心清心泻火，心肝肾同治；金钱草清热通淋。合方配伍，具有清肝滋肾之效。

【案例】

病由丧子，悲愤抑郁，肝火偏盛，小水淋浊，渐至遗精，一载有余，日无虚度。今年新正，加以左少腹睾丸气上攻胸，心神狂乱，龈血目青，皆肝火亢盛莫制也。肾主闭藏，肝司疏泄，二脏皆有相火，相火妄动，虽不交合，精亦暗流而走泄矣。治法：当制肝之亢，益肾之虚，守越人东实西虚，泻南补北例。川连、黑栀、玄胡、赤苓、沙参、川楝子、鲜地、知母、黄柏、龟板、芡实，另当归龙荟丸一钱，开水送下。（《柳选四家医案·环溪草堂医案·下卷》）

【按语】

本案肝火而兼肾虚，因情志抑郁，继而小便淋浊，衄血目青，心神狂乱，皆一派肝火之证，但木火之所以有余，由金水之不足，金不制木则木旺，水不制火而火炎，故采用秦越人“泻南方，补北方”之法为治。

九、肝火动血

症状：烦热胁痛，胀满动血，或咳血、呕血、吐血、衄血，或脘痛而有积气。舌红，苔黄，脉弦数。

证候分析：肝郁化火，火旺伤阴，是以烦热胁痛而胀；热扰肝血，肝血不藏，故见咳血、呕血、吐血、衄血等血证；木火横逆，顺乘阳明，则脘痛而有积气。舌红苔黄，脉弦数，为肝火之征。

治法：清肝平肝，凉血止血。

方药：化肝煎加减。

白芍12克，青皮10克，陈皮10克，丹皮10克，山梔12克，土贝母9克，泽泻10克，生地15克，玄参12克，白茅根30克。

肝热甚而目赤颧红者，可加羚羊角；若出血不止，可加小蓟、茜草、犀角。

方义：白芍敛阴以护肝；青、陈皮疏肝以利气；丹、梔凉血以清肝火，因气火煎熬津液成痰，故加土贝母解郁化痰；泽泻滋阴利水以协疏泄；又加生地、玄参养阴清热凉血；白茅根止血而治吐衄。

【案例】

王某，男，21岁，工人。右侧鼻衄，反复发作两年，屡用归脾诸方而效不显。就诊时，患者鼻衄不止，量多鲜红，周身乏力，心慌气短，口干不欲饮，大便2~3天始解一次，口唇干渴，皮肤黧黑，舌质红，苔薄黄，脉弦细数，血小板计数为6.3万。辨证为肝气化热，热迫血行，治以清肝凉血为法。方用：

水牛角粉6克（另冲），生地15克，赤芍 10克，丹皮9克，小蓟10克，龙胆草9克，犀角末1克（另冲），茅根15克，青黛6克，玄参15克，茜草10克。

此方服至10剂，鼻衄不发，唯感头晕而已。血小板升至10.5万，舌红苔薄黄，脉弦细小数。综合以上脉证，仍为血热未净之象，于上方清热凉血中，佐以清络之法：

生地15克，丹皮9克，赤、白芍各9克，当归9克，玄参15克，女贞子15克，青黛6克，连翘10克，银花10克，莲子心6克，丹参12克，旱莲草12克。

服至20剂，其病痊愈。

【按语】

本案始以清肝凉血为法，故药后衄血得止。又因肝与心包同属厥阴，而手厥阴心包又主管营血，故衄止后，佐用清营络之药，使深伏营分之邪热得以透解，以巩固疗效。

十、肝火下迫大肠

症状：下痢后重，腹痛里急，大便脓血，渴欲饮水，肛门灼热，舌红，苔黄腻，脉弦数。

证候分析：热性本急，湿性则缓，湿热下迫于肠，肝不疏泄，故便下脓血，里急后重，肛门灼热。舌红苔黄腻，脉弦数，皆肝经湿热之征。

治法：清肝燥湿，坚阴止痢。

方药：白头翁汤。

白头翁12克，黄连9克，黄柏9克，秦皮10克。

方义：方以白头翁为君，为清肝凉血之专品，配黄连清湿热厚肠胃；黄柏泻下焦之火以坚阴；秦皮苦寒而清肝凉血。

【案例一】

陈氏，湿热经旬不解，发热自利，神识有时不清，此邪伏厥阴，恐致变痉：白头翁、川连、黄芩、秦皮、生白芍、黄柏。

【案例二】

蔡某，内虚邪陷，协热自利，脉左小右大，病九日不减，是为重症，议用白头翁汤加黄芩、白芍。（《临证指南医案·疾》）

【按语】

“邪伏厥阴”、“内虚邪陷”，指肝火下迫大肠，这里的“内虚”，是指误下，抑或肝阴不足；“邪伏”是湿热伏于厥阴；“邪陷”是指传经之邪陷入厥阴，故皆以白头翁汤清肝凉血止痢。加入黄芩、白芍，乃有黄芩、白头翁合方之美，而清肝胆之热。

肝火内燔之证，种种不一，既可游行于三焦腠理，也可充斥一身上下内外。王旭高云：“肝火燔灼，游行于三焦，一身上下皆能为病，难以枚举。如目红颧赤，痉厥狂躁，淋浊疮疡，善饥烦渴，呕吐不寐，上下血溢等皆是。”（《西溪书屋夜话录》）

肝火燔灼的治疗原则，应本着“木郁达之”、“火郁发之”、“寒者热之”的原则，分其在上在外，宜清宜散；在外在内，宜泄宜攻。如金不制木，必佐以清金；水亏木旺，宜滋水以涵木；兼有心火者，泻心为先；郁怒化火者，清化是务。总之，宜根据气郁轻重，火亢程度，病位浅深，分别进行辨证论治。

第四章 肝火伤阴证治

从肝病发展来看，肝气化火之后，必然有伤阴之举，上章内重点讨论肝火证治，因肝火燔灼，宜侧重于清泻肝火，本章内准备讨论肝火伤阴证治，重点讨论伤阴后的证治规律。

中医学认为：阳气与阴精是相互对立统一的辩证关系，是人体赖以保持“阴平阳秘”正常生理功能的必要条件。“阴具有涵阳”的作用，阴充阳涵，才能使阳不浮而“秘”，若阴不充而阳不得其涵，则阳易浮而无制。因此，明辨阴精的损伤与否，损伤的程度如何，何脏损伤等，对指导肝病的治疗，揭示肝病的预后、转归，都有重要意义。由于火易伤阴的特性，所以肝火伤阴尤为多见。

阴精是精、血、津、液等基础物质的统称。人身之形赖其充养，五脏六腑、皮肤毛管、五官九窍、四肢百骸，皆赖其濡润。若以脏阴为例，无一脏不是以阴为基础而使其功能得以发挥。肝得阴则化刚为柔，而遂条达之性；肺得阴而养其娇，使其清虚而宣降；心得阴而神明不乱，血脉充养；肾得阴而主蛰，并赖以涵肝、济心；胃得阴而能纳降，脾得阴而能运化，脾胃得阴，始能阴濡阳充，升降自如；肠得阴而能传化畅通，膀胱得阴而能资助气化，由此可见，人身不可无阴的濡养，无阴则阳无以化，这是生命运动的基本规律。

肝火伤阴，既可自伤，也可伤及他脏之阴。从病变发展过程来看，尤以自伤肝阴，中伤胃阴，下伤肾阴为最多见。自伤肝阴，则以伤肝血为易见，表现为：眩晕、消瘦、脉细、舌质淡，及妇女经少、经淡、经闭等症；中伤胃阴，则以伤胃中津液为主，表现为：胃中灼热，口咽干燥，睡后尤为明显等症；下伤肾阴，则以伤肾精为最，表现为：五心烦热，腰腿酸软，眩晕耳鸣，舌光红无苔等症。尽管由于伤阴程度与脏腑密切相关，但因为精血津液同源，所以在病变时，常常损则俱损，荣则俱荣。这就说明，我们在辨证时，既要注意与脏腑的关系，也要动态地观察其内在联系。

脏阴亏损，所以不同，治有差别。肝阴虚重在养血护阴；胃阴虚重在清润救液；肾阴虚重在滋腻厚味。不识其主次轻重，滋养不当也会影响疗效。温病中易伤津液，肝火则易伤肝、胃、肾之阴。热病伤阴其来

亦骤，阴液恢复也易；肝火伤阴，往往渐积而成，非一朝一夕所能恢复。诚如陈良夫所悦：“五志所化之火为内火，虽不及热病，但其害则胜过热病，积以时日，大有吸尽西江之水之虞。”（《陈良夫医案》）

论治肝火伤阴，重点虽在养阴，但阴虚则火旺，在滋培阴精之时，应当视火邪亢烈程度，略佐清降之品，但忌苦寒化燥，更伤其阴。现对其证治规律，分述如下：

一、肝火自伤肝阴

肝火太过，肝阴必伤，因肝火亢烈为害，则宜清宜泻，因阴虚而火旺，则宜滋宜养。因此肝火自伤肝阴，治宜养肝阴为急。

症状：头痛眩晕，耳鸣，右胁痛，面红舌干，齿衄便血，脉弦而细数。

证候分析：肝火旺，则齿衄便血；肝络不和，则右胁作痛；虚火上犯，故耳鸣。肝内寄相火，血虚则不能制气，阴虚则不能潜阳，是以头痛眩晕，面红舌干，脉弦细而数也。

治法：养肝阴，平肝火。

方药：养阴平肝汤。

生熟地各12克，女贞子12克，潼蒺藜9克，枸杞9克，怀牛膝10克，白芍12克，菊花10克，钩藤10克，煅石决明12克。

方义：方中以生熟地、女贞子、蒺藜、枸杞滋水涵木，以养肝阴；白芍敛护肝阴；怀牛膝养肝肾之阴而引血下行；菊花、钩藤、石决明平肝火，定肝风。全方配伍，重在养阴平肝之用。

【案例】

鲁某，男，49岁。头晕耳鸣三月，予平肝泻火不效，化痰通络不愈，转见胸胁闷痛，筋脉时抽搐，苔黄薄而糙，脉细弦而沉，诊为血不营肝，虚火时起，守养阴平肝汤，10剂而愈。因证属下虚上实，标本兼顾而效捷。

二、肝火中伤胃阴

症状：口燥咽干，尤以睡眠后明显，自觉胃中灼热，心烦，食减，甚至厌恶荤腥，心下痞闷，噫气不除，或胸胁发满，其脉弦细，舌红而绛，少苔或无苔。

证候分析：肝气郁结，初起而肝阴不伤者，可用疏肝理气之法。日久化热伤阴，多属血不制气，阴不潜阳之证，其治当与前者迥然有别，魏柳州说：“阴血不虚则肝叶柔而下垂，阴血不足又加怒火，则肝叶燥而升举。”魏氏的肝叶垂、举之说，虽不足信，但是血虚之后，肝气横逆则是必然结果。因此，治疗阴虚的肝气，当投以甘寒凉润，忌用香燥辛热，以防劫阴。本证口燥咽干，尤以睡眠后明显，自觉胃中灼热而心烦，为胃中津液不足，胃气不和之象；饮食减少，乃胃阴虚而内热之征，肝气不得胃津之柔，则气逆而上，故胸胁发满，心下痞塞，而噫气不除；脉弦细主肝病而阴虚；舌红绛少苔，主阴虚而有热。

治法：滋胃柔肝。

方药：益胃和肝汤。

玉竹10克，生地10克，麦冬15克，沙参15克，枇杷叶6克，荷蒂6克，川楝子6克，白芍6克，佛手9克，郁金9克。

方义：用玉竹、麦冬、沙参、生地补益胃阴，以制肝气之横；枇杷叶、荷蒂降胃气之逆，以治噫气；川楝子、佛手理气疏肝而不助燥；白芍平肝，郁金解郁。

【案例】

吴某，男，32岁。患病一年之久不能食，虽食则胃脘胀满，嗳呃而胃中有声，两胁胀满，口咽发干，以睡眠后尤甚。医以其食减腹泄，认为脾虚，投以人参健脾丸，诸证未止，夜寐梦遗，脉弦细，舌尖红如锦。证候分析：脉弦，病在肝胆，细脉又主阴虚，舌红如锦，则阴虚之象不难辨认；口咽干燥为津液不滋；胃脘胀满，为肝胃失和；风阳内迫肠胃则便泄，故不能饱食。此证宜甘寒生津柔肝，戢其阳用之过则愈。今误用辛燥，助阳灼阴，甚则伤阴动火，而精关为之不固。治法：柔肝

养胃。方守养胃柔肝汤，服20剂，其病即愈。

讨论与体会：养胃阴学说是由叶天士提出，后来的医家亦颇重视，临床上只要见到：口咽发干，以睡后明显，不思饮食，或知饥不食，并有心烦低热，大便干燥，干呕作呃，舌红少苔，或无苔，或舌中心光剥，脉象细数等症，即可诊为胃阴不足。

“纳食者胃，运化者脾”，“阳明燥土，得阴自安”，故胃之刚燥，必济之以柔润，胃之和降必以通为补，所谓“六腑以通为补”也。然养胃之法既非辛开苦降可用，亦忌苦寒下夺，只须甘平、凉润以养胃阴，叶天士养胃汤可用。然则欲养胃阴，当恰如其分而不偏不倚，斯为善养。具体而言，有以下七个方面的治法：

1.甘寒

凡燥热之症，火盛灼液，或病后肺胃津亏，以致虚痞不食，舌绛咽干，烦渴不寐，肌燥灼热，便下不爽，“头痛耳鸣，九窍不利，此肠胃之所生也”，当甘寒、甘凉以养胃阴，候津液来复，使之通降则已。吴鞠通云：“舌绛而光，当濡胃阴。”方如叶天士养阴汤、鞠通益胃汤、五汁饮、玉竹麦冬汤、清燥汤等，如不能济之以甘寒，“恐液亏燥起而成干咳身热之怯症。”吴鞠通又说：“燥伤胃阴与燥伤肺阴同法，所以谓救胃即所以救肺也，故用药无大异。”但临床选方用药应略有出入，润肺宜取轻清，养胃宜取气味略厚之品。

2.甘酸

胃阴不足，易致肝失疏泄，取酸味入肝柔筋养血，甘寒养胃生津，酸甘合法，两济其阴。凡胃阴不足所致不饮不食而潮热，得食而烦热愈加，津液不复者；肺阴不足而消渴、咯血、干咳少痰者；肝阴不足而脘腹痛、便血，甚则筋挛者；均可用此法进行加减，若肝阴虚，胃汁竭，可选用乌梅、木瓜、玉竹、人参、生地、阿胶、麦冬汁、白芍等味。

3.甘辛凉

胃为肺金之母，凡外感燥邪，或肺燥胃阴伤，多在甘凉之中佐以辛宣，以辛凉甘润肺胃为先。如干咳无痰，气逆而喘，咽燥胁痛，口渴，舌质红苔白而燥，可选用清燥救肺汤、桑杏汤、麦门冬汤、竹叶石膏汤等。大凡津液干结而为患，当佐以辛通之品，以宣通气机，不宜一味敛清呆补。

4.甘咸寒

阳明燥热迫及肾阴，以致肾阴将涸，亡阴失水，治宜甘寒之中，佐以甘凉柔镇之品。咸可利胃，质之柔以补阳中之阴，症见：口燥咽干，神倦欲眠，舌赤苔老，脉结代，可用加减复脉汤以复其阴；若脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱，甘酸咸之大定风珠汤投之，救得肾液，始保胃津，即使是肾液耗伤不甚，亦可佐咸润以安受邪之地。

5.甘平

土为万物之源，胃为养生之主，胃强则身强，胃弱则身弱，是以养胃阴济以甘平。甘平之品无偏寒偏热之弊，又有益气生血之功。周慎斋说：“胃有邪火，宜养不宜燥.....养者，养胃阴也。”并说：“胃脉豁大，四君子加麦冬、五味，补气以养阴，阳生阴长。”唐容川在《血证论》中说：“血少津枯，易于停食者，多是胃中有热，贪多饮食，既食之后，脾津枯少，不能糜烂消化。易于停食，宜四君子汤加黄精、山药、玉竹参、花粉、麦芽、白芍、生地、当归、麦冬、山楂、莱菔子汁煎服，此等治法，但读东垣《脾胃论》断不能知也。”其实，凡五脏阴血津液耗伤，或老年纳谷不佳，皆可甘平调之。

6.甘淡

土薄力弱，生化无权，胃阴不复，胃气不足，临床常见到：病后不饮少纳，神疲溲黄，舌绛苔腻等症。治疗上甘温益气嫌其燥，甘寒与甘平之剂又不免过柔，当法取甘淡，即甘守津回，淡渗运脾，药如：芦根、苡仁、茯苓、石斛、生扁豆、生谷芽、粳米等等。

7.食养

食养之法，首当注意食复，热病胃阴未复，强食后则“谷气相搏，两热相合”而病复，治之以清淡滋润饮料为上，吴鞠通所制中乳饮、雪梨浆等，配合休息而使人康复。

由此可见，养胃阴之说的创立，大大丰富了柔肝之治，仲景一部《伤寒论》，其宗旨即是“保胃存津”。后世温病学家对养胃滋阴尤为重视，王孟英说：“凡治外感证，须审胃汁的盛衰，如邪渐化热，即当濡润胃腑，俟得流通则热有出路，液自不伤，斯为善治。”这就说明外感热病中濡养胃阴之重要。在肝病发展变化过程中，濡养胃阴亦同等重

要。叶天士说：“胃为阳土，以阴为用，木火亢制，都是胃汁之枯。”因而，叶氏重视“通补阳明以制厥阴”之治，其道理即在于此。

三、肝火下伤肾阴

症状：烦躁面红，目赤带眵，性急易怒，男性阳易勃起、梦遗走泄，五心烦热，腰腿酸软，舌光红无苔，脉弦细数。

证候分析：阴虚阳动，水虚火燔，故烦躁，面赤，目赤带眵，性急易怒，梦遗走泄。舌尖红无苔，主阴液损伤；脉弦细数，主阴虚火动。

治法：滋肾水以和阳。

方药：知柏地黄汤。

生地10克，熟地10克，丹皮10克，白芍10克，知母6克，黄柏6克，山药10克，山萸肉6克，泽泻6克，茯苓6克，龟板10克。

方义：用六味地黄汤以滋肾水，加龟板大补真阴，白芍平肝养血，生地凉血柔肝，知母、黄柏以泻相火之旺，此“壮水之主以制阳光”之法。

【案例】

吕某，男，37岁。患慢性肝炎，续发阴虚火动，经常梦遗，见其爱人，即欲性交。会阴部与耻骨和龟头时发瘙痒，一痒则阴茎勃起，经久不衰，并伴有失眠、心烦、口苦、咽干等证。望诊所见：患者两颊绯红，两目生眵，舌绛而苔黄腻，额上涔涔汗出。切其脉弦细且数，辨证：肝病日久，阴受伤而相火旺，阴不制阳，阳用过极，而续发以上诸证。治法：泻肝肾之火，补已虚之阴。方药：柴胡9克，胆草9克，知母9克，黄柏9克，当归9克，白芍15克，生地12克，女贞子15克，旱莲草15克。

服三剂而梦遗未发。惟小便浑浊，小腹胀痛而已。转方用：苍术9克，黄柏9克，知母6克，胆草6克，木通6克，泽泻6克，以清下焦之湿热，则阴痒与小腹之胀随之而愈。

【按语】

肝藏血而肾藏精，然皆内藏相火，若血与精两伤，则肝肾之火必炎，诸证必然丛生。

四、肝肾阴虚，虚火上炎

症状：低热起伏，胁痛气胀，呕吐酸水，舌红绛苔薄黄，脉弦细数。

证候分析：阴虚则内热，水亏则火旺，是以低热起伏；肝血虚少，阴虚气滞，则胁痛；肝火犯胃则呕吐；舌红绛苔薄黄，脉弦细数，无非阴虚火旺之症。

治法：滋补肝肾，佐以清肝。

方药：滋水清肝饮。

熟地12克，山萸10克，山药12克，丹皮10克，茯苓10克，泽泻10克，柴胡6克，白芍10克，山栀子3克，酸枣仁10克。

方义：该方由六味地黄汤加白芍、柴胡、山栀、枣仁而成。六味地黄汤原载《小儿药证直诀》，专为真阴亏损，虚火上炎者设。今阴虚生内热，血虚则肝燥而不柔，故加入白芍、酸枣仁护阴安魂，栀子清三焦游热，柴胡疏利肝气，从而肝肾同治。

【案例】

阁老李序庵，有门生馈赠坎离丸，喜而服之。余曰：“前丸乃黄柏、知母，恐非所宜服者。《内经》有云：壮火食气，少火生气，今公之肝肾二脉，数而无力，宜滋其化源，不宜泻火伤气也。”不信，服将两月，脾气渐弱，发热愈甚，小便涩滞，两睾肿痛。公认为疮毒，余曰：“此肝肾二经亏损，虚火所致耳，当滋补为善。”遂朝用补中益气汤，夕用六味地黄汤，诸证悉愈。余见脾胃素弱，肝肾阴虚而发热者，悉服十味固本丸，与黄柏、知母之类反泄真阳，令人无子，可不慎哉。”（薛注《明医杂著·医论》按）

【按语】

肝肾阴虚，可致虚火上炎，或肝火燔灼，亦可伤伐肝肾之阴，但论治有别。前所论二证，虽可从六味地黄汤滋补肾阴基础上演变，但本案系因龙雷之火而不潜藏，治则大别矣。本案贵在用补中益气汤升举清阳，以消阴翳，则阴火自除，复以六味地黄汤培肝肾之本，则龙雷之火不再升腾矣。若蛮用苦寒之品以直折，反泄真阳，变证就会立起，故附此案以资鉴别，

综上所述，肝气化火，必然灼伤阴血，其所伤之阴，关系五脏之阴，而以肝阴、胃阴、肾阴为多见。血为阴类，肝赖血以养，肝血虚则阴虚，肝体必不柔而为病；胃阴关系十二经，“十二经皆禀气于胃，胃阴复而气降得食，则十二经之阴皆可复”（《温病条辨·中焦篇》）。肾阴为五脏脏阴之根，“五脏之阴非此不能滋”。且肝肾精血同源，肝病关系肾阴而尤亟。因此，肝气化火伤阴，重点在肝阴、胃阴、肾阴，抓住重点，辨证论治，自可收到事半功倍之效。

第五章 肝风证治

肝风系指内风而言。其发生原因：①阳气有余所变，如叶天士说：“内风乃身中阳气变动。”②是由肝火发展而来，王旭高说：“内风多从火出”。因肝为风木之脏，主动主升，故在肝病过程中，凡是抽搐、震颤、眩晕等动象，都与肝风有关。现将肝风证治，概述如下：

一、肝火动风

“内风多从火出”，火乃气郁而变，故风虽由火生，实从气郁而化，故始于气分，继则传营入血，产生种种病变。

（一）气热风动

症状：高热汗出，口渴欲饮冷，手足痠痲，或颤项强直，舌苔黄燥，脉弦滑数有力。

证候分析：由于阳明热盛，引动肝风而发。阳明有热则汗出高热，口渴饮冷，舌苔黄燥；肝风内动，则手足痠痲，颈项强直，而脉弦滑有力。

治法：清热生津，凉肝熄风。

方药：加减白虎汤。

生石膏30克，知母12克，甘草6克，粳米10克，生地12克，玄参12克，麦冬20克，羚羊粉1克（另冲），杭菊花炭10克，丹皮10克。

方义：用白虎汤清阳明无形之气热，加生地、玄参、麦冬生阴液以制阳光，加羚羊、菊花炭、白芍、丹皮平肝熄风以治拘急之证。

【案例】

李儿，甫周岁而患温病，由于误服刚燥之药，继发高热，汗出不退，口渴心烦，四肢抽搐，且不时昏绝。脉弦滑而数，舌质红绛，而苔则薄黄燥。辨证为温热袭于气分，阳明热盛，灼津耗液，而引动内风之证。治当清热滋液，平肝熄风为法。方用：生石膏30克，知母10克，玄参10克，生地10克，甘草6克，白芍10克，羚羊角粉2克（冲服），生龙骨12克，牡蛎12克，麦冬12克，竹叶6克。

此方服一剂而热退大半，又服一剂而热不发、抽搐止，乃以五汁饮意调理而安。

【按语】

气热动风，清气分之热是为主法，热盛伤阴，故必滋液，风动而搐不止，平肝即可以熄风，是案投效，可资证明。

（二）营热风动

症状：身热晡甚，口渴而不欲饮，烦躁，两目上视，手足瘈瘲，颈项强直，甚则角弓反张，舌红绛无苔，脉弦细而数。

证候分析：肝藏血主动，心主血属营，热入心营，伤及肝血，可见动风之证。心营热盛，故身热夜甚，口反不渴；邪扰心包，故心烦躁扰，甚则谵语、狂躁；肝热生风，血不养筋，故筋急而动风，两目上视，颈项强直，角弓反张，舌红绛少苔，脉细数，皆心营热盛，肝热伤阴之征。

治则：清营透热，凉肝熄风。

方药：清营汤加减。

犀角粉3克（另冲），细生地15克，玄参10克，竹叶心12克，麦冬心10克，黄连6克，银花10克，连翘心10克，钩藤6克，羚羊角粉1克（另冲），丹皮10克。

方义：犀角咸寒，清心营之热，配生地、玄参、麦冬、丹参以养

阴，甘寒咸寒并用，养营阴而清营热；黄连苦寒清心泻火，银花、连翘、竹叶轻清透泄，宣透气机，使营分热邪有外达之机。营热得除，肝热可清，营阴得复，肝阴亦充。加入羚羊清肝热，丹皮凉肝血，钩藤平肝风，是以有清营热，熄肝风之效。

【案例】

抗日战争时，予僻处山岩，一日傍晚，有彭名少妇来请出诊曰：病孩惊厥已三日，音哑鼻扇不知人。遂与同往。至则见病孩僵卧床上，目正圆，青筋暴露，舌上无津，干缩，皮肤亢燥，郁热蒸蒸，询知发热八九日，三日前狂谵，续变晕厥，诊脉弦劲。予曰：热入心包，风阳上巅，心脑遭震撼，液为火蚀，窍为邪闭，病已濒危。拟方润液救津，撤热散结，宁心透络，回苏醒窍。用鲜生地一两，玄参心四钱，连翘心、连心、麦冬各三钱，莲子青心七分，卷心竹叶四十片，苦百合四钱，犀角八分磨冲，冲服。鲜芦苇茎三两，煮水煎药，分两次化服至宝丹一粒，当晚一剂，明日晨午一剂，下午复诊，病无进退，询知多日未大便，仍用煎剂，改至宝丹一粒为紫雪散二钱，二次化服。越日再诊，得大便一次，皮肤微似汗，眼活动，半有知觉，惟不语，仍以前药，再化服至宝丹一粒，翌日厥回神清，知呼饮，后以清宫、清络、生脉、复脉加減痊愈。（《冉雪峰医案》）

【按语】

本案热入心包，风阳上巅，手厥阴心包与足厥阴肝同病，治从清营凉血入手，佐百合、芦根以清热养心安神，配至宝丹、紫雪散交叉互用，开窍醒神，是以获效如响。

吴鞠通治大人暑病，言其病理为“热初入营，肝风内动”；论其治法，守清营汤加钩藤、丹皮、羚羊角。毕竟营为血中之气，营热必波及血热，亦可出现血热风动，或使病情加重。

（三）血热风动

症状：壮热神昏，头晕眼痛，手足抽搐，颈项强直，角弓反张，甚则四肢厥逆，吐血衄血，全身泛起红斑，舌干绛，脉弦数。

证候分析：血不养气，阴不潜阳，皆可致气动为火，阳动风旋。气血皆热，迫血妄行，是以周身壮热，又见吐血、衄血、红斑等症。热蒸头目，故头胀痛；肝风随阳而动，是以手足抽搐，颈项强直，角弓反张。正邪相争，阳气郁闭不达于四末，故四肢厥逆。舌干而绛，脉弦而细数，乃肝家血热伤阴之征。

治法：凉肝熄风，镇肝潜阳。

方药：犀角地黄汤加味。

犀角 9 克，生地 12 克，丹皮 10 克，白芍 10 克，甘草 6 克，玄参 15 克，竹叶 6 克，麦冬 10 克，紫草 6 克，石决明 30 克。

方义：本方以犀角地黄汤凉血止血，养阴平肝；加玄参、紫草以消斑毒，竹叶清虚热，麦冬养心胃之阴，石决明镇肝以潜阳。

【按语】

本证重点是血热，古人云：“治风先治血，血行风自灭。”但对于血热动风者，则宜遵照“治风先凉血，血凉风自灭”原则。因此，治疗重点在清肝凉血。本证较营热动风有别：营热动风乃营阴之虚，致营热而风动，虚实夹杂；本证乃肝经血分实热，以火盛为仇，两者宜加以鉴别。

“风性则动”，凡动象皆由于风，故《内经》有“诸风掉眩，皆属于肝”之论。在肝病过程中，“内风都由火出”，所以因肝火而生风者，颇为多见，其辨治宜分清在气、伤营、入血的不同变化，而予以恰当治疗。

二、肝阳上亢

风随阳而动，是以手足抽搐，颈项强直，角弓反张。正邪相争，阳气郁闭不达于四末，故四肢厥逆。舌干而绛，脉弦而细数，乃肝家血热伤阴之征。

治法：凉肝熄风，镇肝潜阳。

方药：犀角地黄汤加味。

犀角9克，生地12克，丹皮10克，白芍10克，甘草6克，玄参15克，竹叶6克，麦冬10克，紫草6克，石决明30克。

方义：本方以犀角地黄汤凉血止血，养阴平肝；加玄参、紫草以消斑毒，竹叶清虚热，麦冬养心胃之阴，石决明镇肝以潜阳。

【按语】

本证重点是血热，古人云：“治风先治血，血行风自灭。”但对于血热动风者，则宜遵照“治风先凉血，血凉风自灭”原则。因此，治疗重点在清肝凉血。本证较营热动风有别：营热动风乃营阴之虚，致营热而风动，虚实夹杂；本证乃肝经血分实热，以火盛为仇，两者宜加以鉴别。

“风性则动”，凡动象皆由于风，故《内经》有“诸风掉眩，皆属于肝”之论。在肝病过程中，“内风都由火出”，所以因肝火而生风者，颇为多见，其辨治宜分清在气、伤营、入血的不同变化，而予以恰当治疗。

“阳亢之本，源于水亏”。在肝病过程中，因水亏不能涵木，或肝主体阴不足，导致肝阳上亢，本虚标实，急则治标，以平亢阳之急。其证治规律有如下几种：

（一）风阳上冒

症状：头目昏眩，手足抽搐，或头痛不止，猝然倒地等。

证候分析：肝热亢盛，脏阴被耗，肝阳升动莫制，直冒巅顶，神明被扰，从而头目昏眩，疼痛不止，甚则猝然跌倒，两手足抽搐。

治法：熄风和阳。

方药：熄风和阳汤。

石决明30克，珍珠母30克，钩藤10克，生地黄15克，羚羊角粉2克（另冲），桑叶10克，菊花10克，丹皮10克，白蒺藜10克，白芍10克，牛膝10克。

加减法：脉弦、头胀、耳鸣、颧热，去羚羊、菊花、钩藤，加石斛、茯苓、夏枯草；神昏谵语去生地，加犀角、黄连、菖蒲、郁金，兼痰加胆星、竹沥。

方义：方中用羚羊、菊花清肝，钩藤、桑叶、蒺藜熄风平肝和阳，珍珠母、石决明介类潜阳，生地滋阴凉血，丹皮凉肝，白芍平肝，牛膝有潜阳下行之功，合用则养肝体。

（二）水不涵木，下虚上实

症状：头晕、耳鸣，或口眼喎斜，舌蹇语涩，如身在云中，或兼肉**瞤**，肢麻，下肢痿软无力，足废不能行。

证候分析：肝赖肾水涵养，才能遽其生生不息之机。肾精亏损，肝失所养，则使肝阳上亢。虚风内动，上犯空窍而成下虚上实之势。上实，则风阳鼓动，见头旋耳鸣，烦躁不寐，肢麻，汗泄，甚则昏晕，口眼喎斜等症。下虚，则肾精亏乏，肝阴并耗，见腰酸膝软，步履如悬，遗精，带下，舌红，脉细数或弦数。

治法：厚味填下，介类潜上。

方药：熄风潜阳汤。

熟地12克，龟板15克，牡蛎15克，山萸肉10克，五味子10克，茯神12克，磁石15克，青盐10克，怀牛膝15克，女贞子15克，玄参15克，菊花15克。

加减法：若兼遗精或带下，则去磁石、青盐、牛膝，加芡实、莲肉、金樱子；胃虚不纳，则去萸肉、磁石，加人参、紫石英。

方义：叶天士说：“身中阳化内风，非发散可解，非沉寒可清，与

大气火风迥异。”（《临证指南医案》）厚味填下，意在两补肝肾以实下。方中以熟地、萸肉、五味、龟板、玄参、女贞等品是也；介类潜上，意在重镇潜阳以熄风，牡蛎、磁石等也；牛膝补精强足，引血下行；青盐味咸，导龙入海；茯神交通心神，菊花轻清以祛头风，从而又免阴药呆滞之弊，达交通上下之效。

（三）阴虚阳亢

症状：头目眩晕，或者头目胀痛，满面潮红，耳鸣，目涩，口渴，心烦少寐，下肢无力，脉弦滑或洪大，舌红少苔。

证候分析：阴不潜阳，阳亢于上，故见头目眩晕，或者胀痛；肾开窍于耳，肝开窍于目，肝肾阴虚而阳气上盛，故见耳鸣目涩。心烦少寐，为水火不济之象；口渴为津伤；下肢无力，是阴精失于下；脉洪大，舌红少苔，亦为阴虚阳亢之候。

治法：滋阴潜阳。

方药：滋阴潜阳汤。

石决明30克，珍珠母30克，生牡蛎15克，生龙骨15克，龟板10克，白芍10克，生地10克，丹皮10克，玄参10克，牛膝10克，益母草15克。

方义：石决明、珍珠母滋阴气潜阳下行；生龙骨、生牡蛎镇静安神，导阳下潜；龟板、生地大滋阴精以制阳；丹皮、白芍平肝以凉血；牛膝引药下行，导阳入阴；玄参以滋肾水，且清浮游之虚火，益母草、牛膝引药下行，导阳入阴。

【案例一】

左脉弦，气撑至咽，心中愤愤，不知何由，乃阴耗阳亢之象，议养肝之体，清肝之用。九孔石决明一具，钩藤一两，橘红一钱，抱木茯神三钱，生地三钱，羚羊角粉八分，桑叶一钱五分，甘菊花一钱。（《临证指南医案》）

【案例二】

某，24岁。晕厥，烦劳即发，此水亏不能涵木，厥阳化风鼓动，烦劳阳升，病斯发矣。据述幼年即然，药饵恐难杜绝。熟地四两，龟板三两，牡蛎三两，天冬一两五钱，萸肉二两，五味子一两，茯神二两，牛膝一两五钱，远志七钱，灵磁石一两。（《临证指南医案·眩晕》）

【案例三】

天津于氏所娶新妇，过门旬余，忽然头痛。医者疑其受风，投以发表之剂，其疼陡剧，号呼不止。延余为之诊视，其脉弦硬而长，左部尤甚，知其肝胆之火上冲过甚也。遂投以镇肝熄风汤，加龙胆草三钱，以泻肝胆之火，一剂病愈强半，又服二剂，头已不疼，脉象仍然有力，遂去龙胆草，加生地黄六钱。又服数剂，脉象如常，遂将药停药。（《医学衷中参西录》）

【按语】

案一病属肝风，阴耗不滋，阳亢已急，故重在凉肝熄风以和阳，以羚羊、钩藤、桑叶、菊花轻宣凉肝，配生地养阴，茯神、橘红理气化痰；案二证名晕厥，阴虚于下，阳亢于上，虚实参半，上实下虚，滋阴培肝肾以填其下，平肝降逆以治其上，法从凉润，使“龙雷宁，则水源生矣”；案三以“脉弦硬而长，左部尤甚”为辨证要目，诊为“肝胆之火上冲过甚”，以镇肝熄风而效。由此可见，同属肝阳上亢，但证治有别。

肝病过程中，肝阳上亢者，多不离熄风和阳、熄风潜阳、滋阴潜阳、镇肝熄风四法。肝风初起，风阳上冒，见有冲激之象，多用熄风和阳法；若病情进一步发展，熄风和阳不效，肝阴已伤，则宜熄风潜阳。若阴虚与阳亢，标本俱急，又宜滋阴潜阳，标本同治。若肝阳上亢急剧，肝火之证明显，又宜镇肝熄风，这里要权衡阴虚与阳亢的孰轻孰重。初起侧重于潜阳，后期侧重于滋阴。所以如此治法，阳亢急剧，治宜平肝潜阳，阳亢平息，滋阴即是治本。

三、阴虚风动

肝脏体阴不足，或水不涵木，以虚为主，风由虚致，诸如血虚而肝体不柔，阴虚而阳上扰等证。其证治特点是：

（一）血虚风动

症状：头昏耳鸣，目涩畏光，偏枯在左，脉左缓大，或四肢经络牵掣，或麻木不仁。

证候分析：肝脏体阴不足，阴血亏乏，血虚不能上荣于目，故目涩畏光，视物昏花；肝血不能上滋，阳气发动，故头晕耳鸣；血虚不能荣筋濡骨，内风袭络，故肢体偏枯在左，脉左缓大，或甚则经络牵掣，麻木不仁。

治法：养肝熄风。

方药：养血熄风汤。

制首乌15克，枸杞子10克，当归12克，三角胡麻10克，天麻12克，甘菊15克，石斛12克，怀牛膝15克，小黑豆衣15克。

方义：方中以枸杞、首乌、当归、小胡麻养血和肝，天麻、菊花、薏豆衣平熄内风，石斛滋阳明津液以养四末，牛膝强足补筋兼疗腰痛，并制内风升动。对血虚风动，半身不遂具有养肝和血之妙。

【案例】

钱，偏枯在左，血虚不荣筋骨，内风袭络，脉左缓大。制首乌四两烘，枸杞去蒂二两，归身二两（用独枝者去梢），怀牛膝二两（煎汁），明天麻二两（面煨），三角胡麻二两（打碎水洗十次，烘），甘菊三两（水煎汁），川石斛四两（水煎汁），小黑豆衣四两（煎汁），用石膏加蜜丸极细，每服四钱滚水下。（《临通指南医案·中风》）

【按语】

“旁走者，血虚为多”。肝风旁走四肢，以肝血不足为多。因肝藏血，血虚不能濡养经脉筋骨，是以经络牵掣，甚则麻木不仁。本案即为血虚风动，故投养血熄风之药而有效。

（二）阴虚风动

症状：头目眩晕，心烦不得卧，筋脉拘急，手指蠕动，舌绛苔少，脉细数。

证候分析：热邪久羁，灼伤真阴，阴不潜阳，则头目眩晕；血虚之甚，阴血不能养筋，故筋脉拘急，手足蠕动。夫心肾水火之相交，虽赖脾气为枢，然肾水上济于心，而亦赖肝木为之媒。今肝阴不足，肾水亏而心火亢，致心肾不能交济，是以心烦不得卧。舌绛苔少，脉细数，皆为火旺阴伤之征。

治法：滋阴熄风，平肝潜阳。

方药：阿胶鸡子黄汤加减。

阿胶9克（另烔化），鸡子黄2个（另冲），白芍15克，生地15克，炙甘草6克，石决明10克，牡蛎12克，茯神10克，钩藤10克（后下），络石藤12克。

方义：方中以阿胶、鸡子黄填补真阴；白芍、甘草酸甘化阴；石决明、牡蛎镇肝潜阳；茯苓宁心安神，钩藤、络石藤利关节，熄肝风；生地养阴凉血。全方配伍，具有滋阴潜阳，平肝熄风之效。

【案例】

郑某，男，56岁。身体魁梧，面如赤丹，素以体健自豪，一日手搓干辣椒，辣气冲鼻，顿感头目眩晕，心里非常难受，从此生病，夜间少寐，心烦、耳鸣、头晕、心中惶惶作悸、脉弦而直、舌红少苔，辨为阴虚于下，阳亢于上，手足厥阴风火交炽之证。为疏：生地15克，麦冬30克，炙甘草10克，阿胶10克，生白芍15克，龟板10克，鳖甲12克，牡蛎

20克，石决明30克。

此方连服六剂而病情减轻，头晕与心悸显著好转，又服六剂而基本告愈，后以它方巩固。

【按语】

本案病本乃阴虚于下，其标为阳亢于上，本虚标实，虚多邪少，故治宜标本兼顾。一面用加减复脉汤滋阴填下，一面用牡蛎、石决明、龟板、鳖甲平肝阳之亢，是以再诊即基本告愈。

（三）阴脱风动

症状：神倦瘈瘲，脉气虚弱，舌绛苔少，有时时欲脱之势。

证候分析：本证为肝肾阴竭，水不涵木，筋脉无津液精血以充养，虚风时动，故神倦瘈瘲，脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱。

治法：救阴熄风。

方药：大定风珠。

白芍18克，阿胶10克（另烔化），生龟板15克，干地黄18克，麻仁6克，五味子6克，生牡蛎12克，麦冬18克（去心），炙甘草12克，鸡子黄2枚（后入药汁捣匀），生鳖甲15克。

加减法：气喘而虚者加人参；自汗加龙骨、人参、小麦；心悸，加茯神、人参、小麦。

方义：方中以鸡子黄、阿胶滋阴养液以熄内风，辅以地黄、麦冬、白芍滋阴柔肝，龟板、鳖甲、牡蛎育阴潜阳，炙甘草、五味子酸甘化阴，麻仁滋脾润燥。诸药合用，具有滋液填阴，柔肝熄风之效。若兼见气微作喘，而肺气虚而不敛，急加人参以益气保元；若兼自汗，是气虚不能固表，将成阴阳两脱之势，急加龙骨、人参、小麦以益气敛汗固脱。若兼见心悸不安，系心之气阴两伤所致，则加人参、五味子、小麦益气而养心。

【案例】

阎学生，12岁。温病高热之后，而阴液因之大伤，发脱肉消，神倦瘈瘲，且时时泛呃，不欲饮食，脉弦细而舌红。辨为阴液枯竭，肝木失涵，虚风内动，亟防其脱，乃疏：炙甘草12克，西洋参6克，生地12克，麦冬15克，五味子3克，白芍10克，龟板10克，鳖甲12克，牡蛎5克，火麻仁6克。

此方加减进退，服至30余剂而病方逐渐转安。比及下床，两腿着地，而振振欲擗地，洵属温病伤阴之重证也。

【按语】

此证之瘈瘲，乃阴液大伤虚风内动之象，切不可用羚羊、钩藤等药而使气阴反脱也。

阴虚生风，风由虚致，治法较阳亢者迥然有别。阳亢生风，要视阳亢程度而采用平肝潜阳之法，其中虽然也要兼顾滋阴，但毕竟是邪多虚少，如熄风和阳重在凉肝熄风，熄风潜阳法应用之证，虽然也有阴伤之象，但阴伤并不严重，故仍以潜阳为目的；阴虚生风，则视其阴虚程度，而采用滋补肝肾之阴为大法。如黄连阿胶鸡子黄汤，则重在阿胶、鸡子黄血肉有情之品，质重味厚，育阴熄风，增液润急，至于平肝熄风之品则仅为佐使；大定风珠则用于阴虚风动，邪已去八九，真阴反存一二，是纯虚无实之证，故重在味厚滋补以滋阴养液，从而填补欲竭之真阴，潜摄未尽之浮阳，平熄内动之虚风，务使阳安其位，病情才有转机。加味赤石脂禹余粮汤，用于阴脱阳越，此时阴阳均已告困，虚风内动，故从仲景桃花汤疗少阴阳虚的基础上，一变而为少阴液亏风动，阴阳两补之方。至于血虚生风，旁走四肢，舍补肝养血，则无恰当治法。于此可见，肝肾阴虚，虚风内动证治之各并。

值得提出的是，俞根初在《通俗伤寒论》中谈到“阴下竭，阳上厥”一证的病理及证治规律，很可借鉴。他认为：肾中真阳寄于命门，命门又为精室之门，前通外肾，后通督脉，只要在肾任阴虚的情况下，阳就会无所依附而外越，任阴不足，冲气失纳而上冲，故有“阴下竭、阳上厥”之证，治疗“欲潜其阳以定厥，必先滋其阴以镇冲”，创坎气潜龙汤为治，处方是：坎气（初生脐带）、龙齿、珍珠母、白芍、生地、

牡蛎、磁朱丸、白薇。妙用白芍、白薇，一在敛肝和营，一为纳冲滋任，颇具巧思。

四、肝风挟痰

肝病过程中，因木燥火生，火生风起，更兼脾虚不化水谷精微而生痰浊，痰浊又为风阳扇动，则痰激火生，火生风煽，交炽为患，诸证频起。

（一）风痰交炽

症状：头眩晕，呃逆清水，胸痹室塞，神烦不寐，肢麻，纳少痰多，甚则癫狂昏仆，脉弦滑。舌红苔黄腻。

证候分析：“诸风掉眩，皆属于肝”，“无痰不眩，无火不晕”，风火夹痰交炽为患，故头目眩晕、肢麻；扰胃则呃逆清水，扰神则神烦不寐，扰脾则纳少痰多；阻滞胸膈，故胸痹室塞；痰火迷神，故见癫狂昏仆。脉弦滑，舌红苔黄腻，为痰火之征。

治法：祛风化痰，佐以清热降火。

方药：二陈汤加味。

法半夏12克，胆南星10克，橘红12克，茯苓15克，天竺黄10克，甘草3克，钩藤15克（后下），石菖蒲10克，天麻15克，黄连10克。

方义：方中以二陈汤燥湿化痰，天竺黄、菖蒲、胆南星以清化热痰，天麻、钩藤以平肝风，黄连清热泻火，使痰火降而风自熄。

【案例】

曾治皇城峪一煤矿主人，痰火内发，动风上扰，证见头目眩晕，舌蹇难言，血压升高，面红如醉，痰涎壅盛，脉弦滑且数，舌黄腻而厚。遂用：竹茹15克，胆星10克，半夏10克，黄连10克，胆草10克，羚羊角粉1克，橘红10克，天麻10克，钩藤10克，牛膝10克，益母草10克，茯苓10克。服三剂头晕轻而欲睡，谈说变易，视其舌苔变薄，乃于前方又加白芍12克，当归10克，减去羚羊、胆草，服六剂，而逐渐康复。

【按语】

本案以头目眩晕，舌蹇难言，面红如醉，脉弦滑且数，为辨证眼目，知为痰火内发，动风上扰所致。首诊时，先用黄连温胆汤加平肝之羚羊、钩藤，熄风之天麻，活血降压之牛膝、益母草，苦寒泻火之龙胆。药后即见效机，再诊则去羚羊、胆草，而加入归芍养阴护肝。可见，临证须知随证应变，才能法活机圆。

应当指出的是，痰火风交炽，多本虚标实，一般宜先治其标，以泻火开痰，佐以祛风之药。临床上要注意“二忌三宜”。“二忌”是：一忌劫燥化痰，免伤阴致变；二忌酸涩收敛，免敛邪为患。“三宜”是：一宜理阳明，叶天士说，“痰多必理阳明”，理阳明重在和胃化痰，药如竹沥、姜汁、菖蒲、橘红，可随证加入；二宜扶太阴，虚则扶脾，“脾为生痰之源”，脾升则痰自化，风自熄，若中虚可佐入人参，或兼服外台茯苓饮；三宜咸苦甘凉、佐微酸辛，咸苦酸甘，益阴泻火，以柔济刚，辛味虽阳，以其能通散，助金而制木。用药在“三宜”中权变，可收良好效果。但毕竟肝风夹痰，要平肝熄风与化痰相配伍，是以本法与运脾燥湿熄风的半夏白术天麻汤有别。

（二）肝肾阴虚，风痰内扰

症状：头晕头痛，耳鸣目眩，舌强不能言，足废不能履，口干不能饮，苔腻，脉弦滑，或细数。

证候分析：“肝阴虚，风上巅”，阴虚则血燥，血燥则生热，热甚则风阳上升，是以头晕头痛，耳鸣目眩，口干不欲饮；而痰浊上泛，堵塞窍道，则舌强不能言；肝血不荣于筋脉，筋骨不用，故足废不能履；脉弦主肝风，滑主痰湿，苔腻为痰湿之征。若脉细数，为阴虚较甚。

治法：滋养肝肾，清化风痰。

方药：加减地黄饮子。

干地黄30克，山萸肉12克，石斛12克，五味子6克，白茯苓12克，麦冬12克（去心），菖蒲9克，远志9克，川贝母6克，竹沥水10克（另兑），怀牛膝10克，桑寄生12克，薄荷3克。

方义：用干地黄、山萸肉补肾益阴，辅以牛膝引血下行；桑寄生补

肝肾，强筋骨，佐以石斛、麦冬、五味子滋补阴液；茯苓、菖蒲、远志交通心肾，宣窍化痰，佐以竹沥、贝母以清化痰热，从而标本全顾，诸症可愈。

【案例】

工人于某之妻，病中风右身瘫痪，不能活动，经服药治疗，度过危险而在家中静养。一日突然口不能言，而头目眩晕为甚，乃请余诊，切其脉沉细无力，舌短不能吐出于外，右半身则麻木不仁，亦成偏废不用。余辨为少阴瘖瘵之证。乃宗地黄饮子意加减如下：熟地30克，远志6克，山萸肉10克，石斛30克，麦冬15克，五味子6克，菖蒲10克，茯苓10克，川贝6克，薄荷3克，石决明30克，珍珠母30克，白芍10克。

此方服三剂，而口能言，但欠清晰，头晕瘳。

【按语】

地黄饮子原载《宣明论方》，是温补下元，摄纳浮阳，开窍化痰的一首名方，临床加减以治疗肝肾阴虚，风痰上扰者，疗效颇好。但肝肾阴虚，而有内热之象，一般宜去肉桂、附子、巴戟、苁蓉等温燥助阳之品。

值得指出的是，肝肾阴虚，风痰内扰之症，常常欲培阴又恐痰热难化，欲化痰热又恐伤阴，如何正确做到化痰而不伤阴，滋阴而不敛痰，张山雷在论中风时有一段颇有实践意义的话，他说：“此病最着重处，在痰浊壅塞一层，盖阴虚于下，阳浮于上，必挟其胸中浊阴，泛而上溢，蔽塞性灵，上蒙清窍，以致目瞑耳聋，舌蹇语塞……是以昏瞽之时，痰壅涎流，十恒八九，愚谓潜降急矣，而开痰亦不可缓，则半、贝、胆星、竺黄、竹沥之属，皆不可少……如果不分次序而于气火升浮，痰浊窒塞之初，即用滋腻与潜阳并进，方且以缓摄纳之力，助浊阴之凝，适以僨事而有余。”由此，我们可以领悟到，肝风挟痰，尤其是阴虚痰盛的患者，不得早用滋腻之品，化痰宜用轻清之品，不可主次不分，因果倒置。

五、湿热在经，肝风内动

症状：口噤，四肢牵引拘急，甚则角弓反张，神识昏蒙，舌苔黄腻，脉濡。

证候分析：《素问·生气通天论》说：“因于湿，首如裹，湿热不攘，大筋^痙短，小筋弛长，^痙短为拘，弛长为痿。”湿热壅滞筋脉经络，气血不达，筋脉失养，是以四肢牵引拘急。若湿热壅滞特甚，肝火内盛，风灼经脉，故角弓反张、口噤，湿热蒙蔽心包，可致神识昏蒙。舌苔黄腻，脉濡为湿热内蕴之征。

治法：化湿清热，佐以通络散风。

方药：薛氏胜湿熄风方。

鲜地龙15克，秦艽10克，威灵仙10克，滑石18克，苍耳子3克，丝瓜络15克，海风藤10克，酒炒黄连6克。（注：原方未载剂量，今据临床所用补入，并冠以方名）

方义：方以秦艽、威灵仙、苍耳子、海风藤四药，散风化湿，又能疏肝理气，使湿热去而肝经郁热自解，内风可熄。黄连燥湿清热，滑石化湿清热，地龙、丝瓜络有通络之妙，从而使气血畅达，经络疏通，湿热得化，肝风可除。

【案例】

于某，男，32岁。时值盛夏，水田作业，突感口噤不能开，继则四肢牵引拘急，汗出黏衣，胸闷脘痞，纳差泛恶。延医竟芳香辟秽诸法，旬日未见少减。余诊见舌苔黄腻，脉濡，诊为湿热侵犯经络脉隧，肝风内动，投薛氏胜湿熄风方加减：鲜地龙15克，苡仁30克，秦艽12克，威灵仙10克，滑石18克，苍耳子3克，丝瓜络15克，海风藤10克，酒炒黄连9克，晚蚕沙12克。

服药三剂，四肢拘急减轻，守方续服六剂，苔腻渐化，口噤诸证悉除，转手调理脾胃以巩固。

【按语】

《温热经纬·薛生白湿热病篇》云：“湿热证，三四日即口噤，四肢牵引拘急，甚则角弓反张，此湿热侵入经络脉隧之中，宜鲜地龙、秦艽、威灵仙、滑石、苍耳子、丝瓜络、海风藤、酒炒黄连等味。”薛氏所论虽是指湿热而言，但与湿热伤肝，肝风内动不无关系。若仅限于经络之证，何以口噤？又何以角弓反张？正因为肝失疏泄之职，湿热壅滞伤肝，肝风内动，故见症如此。由是可见，肝风内动，才有四肢拘急，甚则角弓反张诸证。

六、肝风内动，窜犯心包

症状：心悸，神倦欲眠，面赤，舌强语蹇，神愤如寐，或痉或厥，脉细数，心中憺憺大动，甚或心中痛。

证候分析：肝肾阴亏，不能上济心阴，心阴大亏，心包失养，故心悸，神倦欲眠，或神愤如寐。阴伤过甚，舌失所养，故舌强语蹇。阴虚于下，孤阳无制于上，故面赤。阴虚风动，或痉或厥，严重时心阴心气告竭，心失所养，故心中憺憺大动。因心络失养，拘急挛缩，而致心中痛，脉细而数，或细促。细促主脏阴之亏，数主营液之耗，多为血液干涸之象。

治法：滋阴养血，和营止痛。

方药：轻则加减复脉汤。

炙甘草18克，干地黄18克，麦冬（不去心）15克，阿胶10克，火麻仁10克，白芍15克。

重则三甲复脉汤。（即上方加牡蛎15克，生鳖甲24克，生龟板30克）

方义：方中白芍、甘草酸甘化阴，生地、麦冬、阿胶、麻子仁滋阴养血，使血脉充养而心血自营，心悸诸症可愈。若病情进一步发展，肝风内动，心阴心气均告困，再加入生牡蛎、生鳖甲潜阳熄风，重用生龟板养阴安神。

七、脾虚风动

症状：中虚纳少，食不知味，或头重眩晕，肢麻，胸闷气窒。

证候分析：脾虚则纳少运迟，食不知味；肝风内动，则眩晕时作；肝郁则胸闷气窒；清阳不升，湿痰内生，气血不达四肢，故肢麻。

治法：培土宁风。

方药：王旭高培土宁风方。

人参10克，炙甘草6克，麦冬10克，白芍12克，菊花12克，玉竹15

克。

方义：方中以人参扶脾元之气，芍药、甘草酸甘缓急，所谓“缓肝以熄风”；麦冬、玉竹以清润养阴，菊花熄风，是以共奏培土宁风之效。

【按语】

本证重在培土，佐以酸甘养阴以缓肝急，为脾虚风动正治之法。叶天士说：“急宜培养中宫，中流砥柱，风阳不得上越。”（《临证指南医案》）凡是中气虚弱，饮食减少，或劳损营虚，风阳上越，都宜甘温守中，急培脾土。但因为临床所见，在脾虚的基础上，又有兼寒、兼痰、兼风痰的不同，因而其治法，当在培土的原则下，兼用其他不同治法。如：

阳虚寒盛，虚风内动，宜《金匱》近效术附汤：白术15克，炙甘草10克，附子10克。因风挟肾中浊阴之气，厥逆上攻，火不足以暖土，故用白术、甘草以暖土脏，附子温阳暖水，使水土得暖，风邪自熄，此即“暖土以御寒风”之法，非轻扬风剂所能取效。

若虚风震动，湿痰上泛者，宜叶天士熄风祛痰方（《临证指南医案·痰门》）。方用：天麻10克，钩藤12克，茯苓15克，法半夏12克，橘红12克，意取二陈汤去甘壅之甘草，加天麻、钩藤平肝熄风，对肝风夹痰上冒者尤宜。

若脾虚风痰上冒者，宜半夏白术天麻汤，方用：半夏10克，天麻10克，茯苓12克，白术10克，甘草6克，橘红9克，生姜6克，大枣2枚。方以运脾燥湿为主，佐以熄风，尤以天麻、半夏为治风痰上扰要药，正如《脾胃论》所说：“足太阴痰厥头痛，非半夏不能疗，眼黑头旋，虚风内作，非天麻不能除。”

由上可见，虽然脾虚之证相同，但兼证不同，治亦宜有别。

讨论和体会

肝风是肝病发展过程中一个很重要的病变阶段，有其一定的病理基础和证治规律。就其病理而言，肝为风木之脏，喜条达而恶抑郁，体

阴用阳，赖阴血以养其体，宣阳气以舒其用。肝病是体用矛盾的结果，而这种体用矛盾进一步发展，就会形成肝风。如阳气的变动便为风，“风胜则动”；火热的亢极也为风，“火极生风”；阴虚的疲极，亦可出现生风之变。因此，其病理有虚实之并。就其证治而言，由于肝之体用矛盾失调，在很大程度上与阴血亏损有关，阴血的亏损又常随病情发展而不断加剧，所以肝风初起多实，为阳亢之实，此时肝肾阴虚不甚；若肝风日久，肝肾阴伤不仅是发展的必然规律，而且往往邪少虚多，多属虚证，如水亏则肝阳上亢，肾液不荣则肝风鸱张，胃虚竭则木火炽盛，甚至阴亏愈甚，可致肝风愈烈。

肝风的临证表现，主要有肝火动风，肝阳上亢；阴虚动风；肝风夹痰；湿热在经，肝风内动；肝风内动，内犯心包；脾虚风动等七大证候，而每一证候与证候之间又有其内在联系，也有其证候特点。其中以肝火动风、肝阳上亢、阴虚动风为多见。肝火动风的辨治应着眼于辨在气、在营、在血分的不同，论治应有侧重。肝阳上亢，虽然均以阳亢为急，多虚实夹杂，邪多虚少，但仍应区别风阳上冒、下虚上实、肝阳上亢的不同，以区别阳亢的不同程度；阴虚风动是以阴虚为主，邪少虚多，但根据阴虚程度，应分别血虚风动、阴虚风动、阴脱风动，而采用不同治疗措施。

肝风的治疗，总的原则是：养其柔体，济其刚用。因“肝为刚脏，非柔润不能调和”，也即是滋阴养血以培其本；因“肝木性升散”，“主动主升”，风甚则气火升动不熄，故必须潜阳镇摄纳以治其标。标本兼顾，使体用矛盾趋向平衡而肝风可愈。我们在掌握这个总的治疗原则的前提下，还应当注意以下几个问题：

1.应重视甘味熄风

叶天士固然善用滋水涵木，潜降熄风之法，而于甘味熄风亦有独到之处。所谓“甘味熄风”是指运用甘味药物，补养机体阴阳形气之不足，以达到熄风目的。其理论系根据《内经》“阴阳形气俱不足……而调以甘药”，“凡元气有伤，当以甘药例”的原则提出的。具体应用，如缓肝养血熄风，治以甘濡；滋肾液、缓肝急，治以甘寒；因气伤风动，气愈伤，阳愈动则风愈急，治以甘温；肝阳太过，内风扰动，则益体损用，治以甘酸；精血不足，元海根微，以致虚风蒙窍，治以甘咸；精亏风动偏于寒，可遵“肾苦燥，急食辛以润之”的原则，治以“辛甘化风”。由此可见，正确使用甘味药是提高疗效的重要环节。

2.注意调气活血

由于肝气、肝风、肝火，同出而异名，抑而不透便是气，动而炎上即为火，升而不熄便为风，其中共性的规律是气有余而血不足，故应恰当使用调气活血之法。严用和说：“若内因七情而得者，法当调气，不当治风；外因六淫而得者，亦先当调气，然后以所感之气随证治之”。“治风先治血，血行风自灭。”即便是肝风的严重阶段，调气活血之法，亦常不可少。戴元礼说：“治风之法，初得之即当顺气，及其久也，即当活血，此万古不易之理。”可见，调气之方，活血之法，只要使用恰当，可达熄风的目的。

3.适当培阴以固其本

肝风鸱张，“非发散可解，非沉寒可清”，应正确采用滋阴固本之法，使脏阴自安其位，忌用苦寒温燥之品，即便是潜镇摄纳之法，亦只可暂用而不宜久服。若阴虚夹痰的患者，宜在滋补化源和肾水的基础上，配伍轻清化痰之品，以收滋阴化痰之效。

第六章 湿热诸毒黄疸证治

黄疸是以目黄、身黄、小便黄为主要症状的病证。其中以目黄为主要依据，如《素问·平人气象论》云：“目黄者，曰黄疸。”《灵枢·论疾诊尺》也说：“身痛而色微黄，齿垢痛，爪甲上黄，黄疸也。”黄疸之名，古今皆同。

以往医家论黄疸，一般从脾胃湿热和寒湿立论，不属于肝病范围。但也有不少医家确认为黄疸之成，与胆汁外泄有关。如：

《寓意草》云：“胆之热汁满而溢出于外，以渐渗于经络，则身目俱黄，为酒疸之病。”

《临证指南医案》载：“阳黄之作，湿从火化，瘀热在里，胆热液泄，与胃之浊气共并，上不得越，下不得泄，重蒸遏郁，侵于肺则身目俱黄，热流膀胱，溺色为之变赤，黄如橘子色。阳主明，治在胃。阴黄之作，湿从寒化，脾阳不能化湿，胆液为湿所阻，渍于脾，浸淫肌肉，溢于肌肤，色如熏黄。阴主晦，治在脾。”

《景岳全书·黄疸》篇提出“胆黄”病名，认为“胆伤则胆气败，而胆液泄，故为此证。”

嘉言、景岳、天士为历代医家中的佼佼者，他们一致认识到：黄疸的发生与胆液外泄有关。肝胆互为表里，皆主疏泄，肝病及胆，疏泄失职，易出现黄疸，这是很自然的事情了，有鉴于此，我们把黄疸列在肝病证治中讨论。

历代医家对黄疸分类既详且细，《金匱要略》有五疸之辨；《诸病源候论》分二十八候；《圣济总录》列九疸、三十六黄。为了便于临床切用，后世医家总以阳黄、阴黄统之。

阳黄之证，以外感湿热为主，《素问·六元正纪大论》说：“湿热相交，民当病瘴。”湿热交蒸，肝胆失于疏泄，而成黄疸。阴黄之证，以寒湿为主，由于脾胃虚弱，中阳不振，寒湿留滞中焦，肝胆气机不畅，胆液外溢，故成黄疸。阳黄和阴黄的鉴别并不困难，黄色鲜明而不晦暗者，称之“阳黄”，多伴有发热证候；黄而发暗无热象，或见腹满肢冷者，则称为“阴黄”。

除外感湿热或寒湿之外，燥瘀疫毒，皆可久郁互结肝胆而成黄疸。黄疸虽非只有肝病才能见到，但肝病与黄疸却有一定联系。

肝病黄疸具有明显特点：①初伤在气，久必入血，病在气分较少，在血分者尤多。②病位在肝脾。肝气郁结则瘀凝，脾运不健则湿滞，无论是由脾及肝，或由肝及脾，都具有明显的肝、脾两脏的症状。③有明显的传染性。孙思邈说：“凡遇时行热病，必多内瘀着黄。”孙氏把黄疸列时行热病之列，其传染性是可想而知的。

肝病黄疸的治疗，宜着眼于疏、利、清、活、补、温六法的运用。疏，是指疏解肝郁，调畅气机；利，是指利小便，“治湿不利其小便，非其治也”，当然也包括必要时通利大便，以逐瘀热；清，是指清热解毒，对于瘟毒发黄，邪入心包经脉，使用清热解毒法，还必须佐以清心开窍；活，是指活血化瘀，病由气及血，可同时配伍活血、凉血、逐瘀诸法；补，是指健脾而言，健脾即可以化湿，若湿热劫伤肝阴，也必须配伍补肝阴之法；温，是指温中祛寒，对寒湿黄疸，非温则疸不退。为了把握其证治规律，现分述如下。

一、湿热在肝

张石顽说：“目白睛黄，欲发疸也。”（《张氏医通》）“欲发疸也”，是说欲成疸而尚未成。临床上确能见到，湿热在肝尚未成疸的病证，也有的始终不发黄疸，如现代医学所说的无黄疸型传染性肝炎等。因此，为了便于临床掌握，把湿热在肝一证，首先提出讨论。

症状：口苦，心烦，胁满或痛，食欲不振，恶闻荤腥，体疲无力，小便黄赤而短，脉弦细，舌苔白腻。

证候分析：肝胆有热则口苦，心烦；肝气郁则胁满，甚则作痛；气郁不疏而湿热蕴结，是以小便黄赤不利，而舌苔白腻；肝不疏泄，胃气呆滞则不欲饮食；湿热秽浊内结，故恶闻食臭，而饮食衰减；湿性重着困于肢体，则肢体疲倦而不欲动。

治法：疏肝清热，利湿解毒。

方药：柴胡解毒汤。

柴胡10克，黄芩10克，茵陈12克，土茯苓12克，凤尾草12克，蚤休6克，甘草6克。

方义：柴胡、黄芩清肝胆之热，疏肝解郁，故为方中主药；茵陈清热祛湿，利胆退黄；土茯苓淡渗利湿，清热解毒；凤尾草泻热凉血，利尿解毒；蚤休清热解毒，消炎止痛，以上诸药为柴胡、黄芩之佐。

经临床体会，本方对急性肝炎，或慢性肝炎活动期，表现为谷-丙转氨酶显著升高，而又具有上述证情的，用此方多效。

【案例】

张某，男，24岁。患肝炎病已二年，转氨酶500左右，屡治不退，及服五味子粉，旋降旋升，而不能愈。饮食不振，厌油殊甚，闻荤腥亦频频欲吐，切其脉弦，视其苔白腻，问其小便则黄短不利。余辨为湿热入肝，疏泄失司，湿性黏腻，如油入面，而纠缠不解。治当清热解毒，疏肝利胆为法。方用：柴胡10克，黄芩6克，茵陈15克，凤尾草12克，土茯苓15克，蚤休15克，甘草6克。此方服五剂，饮食好转，面色变润。病既转愈，又服五剂，肝功化验，则转氨酶已正常，病逐渐而愈。

【按语】

湿热在肝一证，病因是湿热，病位在肝。因湿热伤肝，肝失疏泄，肝病及脾，脾失运化，湿热又易困脾，因此，调治之法应紧紧把握肝郁与脾困这一对主要矛盾，初期宜采用疏肝与清利湿热相结合，继则脾困颇重，则宜疏肝与健脾淡渗利湿相结合，尤其是无黄疸型传染性肝炎迁延较长时间，更要注意这一点。

二、湿毒凝结

症状：上述之肝经湿热证，经服柴胡解毒汤无效，若其人面色黧黑兼见油垢，虽患肝炎而体重反增，臂背时发酸胀，舌苔白腻而厚，且不易脱落，其脉弦缓者，是以湿毒凝结不开之象。

证候分析：湿痰热蒸，则面色黧黑而有油垢，湿热弥漫而重着难除，故体重反增；湿邪外犯少阳而使经脉不利，则臂背发生酸胀，舌苔

厚腻，难以脱落，是湿热有根难拔之象。

治法：清热利湿解毒。

方药：柴胡三石解毒汤。

在柴胡解毒汤基础上，加滑石、寒水石、生石膏、竹叶以增加清热利湿的作用，加双花清热解毒。

服此方应以舌苔褪落，背臂酸胀不发为病愈。故无论急性、慢性肝炎，凡符合本证者，用之则有效。

【案例】

余在门头沟治一张姓工人，年32岁，患慢性肝炎，胁痛，口苦，呕恶，小便黄短，舌苔浊腻而脉弦。审为肝经湿毒凝结之证，为疏柴胡解毒汤而弗效。舌苔仍厚腻，自称肩膊酸楚，身重懒动，乃改用柴胡三石解毒汤，服三剂而舌苔褪，又服三剂而肩膊之酸楚解，且胃饥知食，身体轻松，为前所未有，从此又治疗月余而病愈。

【按语】

温病学家论治湿热证的理论，可以指导湿热伤肝，湿毒凝结的肝病证治；论病因则以“太阴内伤，湿饮内聚，客邪再至，内外相引”为据，论病机“热得湿而愈炽，湿得热而愈横，湿热两分，其病轻而缓，湿热两合，其病重而速”。愈遏郁则愈缠绵，愈缠绵则愈胶结，治之之法，务使湿热两分。本案初诊以疏肝清热，利湿解毒的柴胡解毒汤而弗效，增入滑石、寒水石、生石膏等甘寒清解湿热之品而竟全功，务在使湿热两分，湿去热孤，胶着之邪始解。

三、湿热黄疸

肝炎有发生黄疸症状者，若其色鲜明如橘子色，则为湿热发黄。邪入于胆，胆液疏泄失序，则一身面目悉黄，然其中又有湿重于热，热重于湿，或湿热俱盛之不同，论治有别。

仲景开黄疸证治之祖。尽管他将黄疸区分为五，除谷疸有似乎急性黄疸外，其余皆多属非传染性。但是，仲景于黄疸一症，列入传染性的“伤寒”病范围之内，就可以说明对肝炎的传染性已有认识，并且认准茵陈蒿为医治肝炎病的专药，偏热者取栀子，晚期病深者取矾石。仲景所创治疗黄疸的方剂，迄今仍广泛应用于治疗肝病黄疸。现就湿热黄疸证治叙述如下：

（一）湿热郁蒸

症状：一身面目悉黄，色明亮而有光泽，身热心烦，口苦欲呕，恶闻荤腥，体疲不支，胁疼，不欲食，小便黄涩不利，大便虽通不爽，口渴腹胀，舌苔黄腻，脉弦滑。

证候分析：黄疸有阴阳之分。本证发黄而有光泽，并伴有身热、心烦、口渴等证，故属湿热郁蒸之阳黄。肝气不疏则胁疼，腑气不畅则腹胀，小便赤黄不利，反映了湿热内盛无路可出。湿热在肝，影响胆液正常排泄而外溢，则一身面目悉黄。湿性黏腻、重着，故使人体疲倦乏力，舌苔黄腻为湿热胶结不解，脉弦滑主肝胆有热。

治法：疏肝利胆，清热利湿。

方药：柴胡茵陈蒿汤。

柴胡12克，黄芩9克，茵陈蒿30克，栀子10克，大黄9克。

方义：柴胡、黄芩清肝利胆，而解肝郁；茵陈蒿清热利湿，专治黄疸；栀子清利三焦，大黄荡涤肠胃，使湿热从小便而去，尿如皂荚汁状则愈。

本方对急慢性肝炎，若出现黄疸而属湿热者，皆可用。对于亚急性肝坏死，虽黄疸隐现黑色，但见尿赤、苔腻、大便不爽、脉弦有力者，

亦可服用本方。此方利小便之力大，泻大便之力小，如久服大便作泻者，可用栀子柏皮汤代替。另外，还可茵陈蒿60克，煎汤代茶饮，以协助清热退黄的作用，亦收佳效。

【案例】

刘某，男，14岁。春节期间，饱食肥甘，又感时邪因而发病。初起寒热似感风寒，不久则一身面目悉黄而成黄疸。发热为38.5℃，恶心欲吐，口苦体疲，周身懒惰，而不欲动，小便赤而大便不爽，切其脉弦而数，视其舌苔黄腻，辨为湿热黄疸，肝胆皆病之证。此病宜疏不宜补，若因体疲误补则邪结难愈。为疏柴胡茵陈蒿汤，服三剂黄退热解，病愈大半，后以他方调治而安。

（二）湿重于热

症状：黄疸，其色鲜明中而带暗滞，一身面目悉黄，肿胀，身重，头如裹，纳差，便溏，腹胀，舌红苔黄白相兼而腻，脉濡不数等。

证候分析：本证发黄，色虽鲜明却带暗滞，且头重如裹、身重，乃是湿邪偏重所致。因湿重于热，故有腹胀、纳差、便溏、肿胀等症，舌苔黄白相兼而腻、脉濡中带数，乃湿大于热之象。

治法：宣气化湿清热。

方药：加减二金汤。

鸡内金10克，海金沙15克，厚朴10克，大腹皮10克，猪苓10克，白通草6克，射干10克，茵陈10克，柴胡6克。

方义：方中用厚朴、大腹皮、鸡内金宣气化湿，以消肿胀；海金沙、猪苓、通草淡渗利湿，以宣通气化；加入柴胡疏肝，射干开痹解毒；茵陈蒿清肝胆以疗黄疸，使湿热之邪，从小便分消。

本方用治湿热发黄而以湿重于热的急慢性肝炎，对于用大量清热解毒法后而黄疸不退，见有上证者，疗效颇好。

【案例】

郭某，女，45岁。体质肥胖，酷嗜肥甘，夏月乘凉，又喝冰镇啤酒，未几而睡，及至天明，则觉周身酸疼，发热，恶心欲吐，服羚翘解毒丸，病不愈，而心中懊恼殊甚，小便黄赤而短，脘腹痞满，闻食味即欲吐，乃延余诊治。切其脉弦而略滑，舌苔白腻而厚，视其目之白睛已有黄色。余对其家人曰：“仲景云：‘阳明病，无汗，小便不利，心中懊恼者，身必发黄’。今病者，心中懊恼为甚，而眼中黄苗已见，恐即将发为黄疸。”然湿邪太重，治当有别。遂书：茵陈蒿30克，泽泻10克，茯苓12克，猪苓10克，通草10克，滑石12克，海金沙12克，鸡内金10克，冬瓜皮10克，藿香6克，厚朴6克，佩兰6克。药未购回，而患者黄疸已现。共赞余之先见，乃亟煎药与服，凡五剂而黄疸病愈。

（三）热重于湿

症状：一身面目悉黄，黄色鲜明如橘子色，身热心烦，脘痞泛恶，便结溺赤，舌红苔根黄腻，脉沉而数。

证候分析：本证发黄而色鲜明，伴有身热心烦，便结溺赤，属湿热郁蒸而热重于湿之候。因中焦湿热阻遏故脘痞泛恶，舌红苔根黄腻，乃热重之象。脉沉主里，数为客热。

治法：宣通三焦湿热，佐以甘辛寒清热。

方药：加味杏仁石膏汤。

杏仁10克，生石膏30克，半夏10克，栀子10克，黄柏10克，枳实6克，生姜汁10毫升（另兑），茵陈蒿30克。

方义：本方苦降辛开，佐以甘辛寒，为苦辛寒合法。方中以杏仁宣开肺气，使气化则湿化，生石膏辛寒以清热而养津，以栀子清三焦之火，黄柏清下焦湿热，以半夏、生姜汁辛开湿结，佐以茵陈退黄。

凡急慢性肝炎，出现黄疸而热重于湿者，可用此方治疗，肝昏迷前期，见湿热伤阴之象明显，亦可用本方略加甘寒养阴之品，以防止病情进一步恶化。

【案例】

刘君之子，年12岁。缘于暑天浴水捕鱼，上蒸下褥，即感寒热，继而身黄、目黄、溲黄俱现，黄而鲜明，如橘子色，胸腹热满，按之灼手，神烦口渴，渴不欲饮，恶心脘痞，便秘，舌边尖红欠津，苔黄腻，脉沉弦而数。经查：黄疸指数52单位，转氨酶350单位，辨证为阳黄。因上蒸下褥，热结于里，病发于阳明胃肠，气分邪热，郁遏灼津，尚未郁结血分，立苦辛寒法以清利湿热，重在清热，仿《温病条辨》杏仁石膏汤加味：茵陈蒿30克，杏仁12克（后下），生石膏30克，炒栀子12克，黄柏10克，半夏5克，生姜汁10毫升（另兑），连翘10克，赤小豆15克。服药十剂后，黄疸明显消退，寒热诸证均罢，后佐以和胃之品，共服三十余剂，诸症悉愈，肝功亦恢复正常。

【按语】

《温病条辨》杏仁石膏汤，用治“黄疸、脉沉、中痞恶心，便结溺赤”的热重于湿之证。方中以清热为主，佐以燥湿宣通，本案即属热重于湿的黄疸证，故投入有效。何廉臣《重订广温热论》与《感证宝筏》言之甚详，值得师法。

湿热阳黄之证，常因热处湿中，湿裹热外，互相交混，缠绵不解。区分湿热孰重孰轻，有利于提高疗效。鉴别湿热孰重孰轻的方法是：

1.湿重于热者

舌苔必白腻，或白滑而厚，或白苔带灰，兼黏腻浮滑，或白带黑点而黏腻，或兼黑纹而黏腻，甚或舌苔满布，厚如积粉，板贴不松。脉象模糊不清，或沉细似伏，断续不匀。症多见：神困嗜睡，凛凛恶寒，头目胀痛昏重，如裹如蒙，身痛不能屈伸，或身重不能转侧，肢节肌肉疼痛而烦，腿足痛而酸，胸膈痞满，渴不引饮，或竟不渴，午后寒热，状若阴虚，小便短涩黄热，大便溏而不爽。治宜苦辛淡清法，轻者可用清热渗湿汤、黄连温胆汤，重者可用梔柏绛矾丸。

2.热重于湿者

舌苔必黄腻，舌之边尖红紫欠津，或底白罩黄，混浊不清，或纯黄少白，或黄色燥刺，或苔白底绛，或黄中带黑，浮滑黏腻，或白苔渐黄而灰黑。症多神烦口渴，渴不引饮，胸腹热满，按之灼手。治宜苦辛佐

淡渗，栀子柏皮汤等。

3. 湿热并重

可分已成实和未成实。未成实者，多见头有汗而身无汗，郁热上熏，小便不利，渴欲饮水，或腹满，可用茵陈蒿汤，凡湿热黄疸兼有消化道症状者多可用之。若未成实者，必多见小便不利，且兼湿热诸症，宜宣膀胱气化，可选用茵陈四苓汤加减。

4. 瘀热在里，热蒸发黄

外而无汗，内则小便不利，可用麻黄连翘赤小豆汤，双解表里为治。若体温较高，黄疸初起，湿热并重，亦可选用甘露消毒丹。

总之，湿热黄疸辨治，要能入细辨证，并能于清利湿热之中，配疏肝解毒诸法，则于临床辨证，思过半矣。

四、湿热伤阴黄疸

症状：黄疸而胆胃湿热不解，少阴之阴复虚，症见：皮肤萎黄，发热而烦渴，胸满口燥，但头汗出，剂颈而还，小便难，或见吐衄，或牙龈浮肿。舌红苔前净而后腻，脉弦而细数。

证候分析：黄疸不解，胃胆湿热而阴分复虚，故见湿热黄疸而又挟阴虚与热伤阴血诸症。因湿热伤阴，邪有燥化的倾向，故黄疸而皮肤干燥，胸满口燥而烦喘，为邪热内盛之征。津液亏乏，水之上源涸竭，故小便难；热邪伤阴，动血于上，故吐衄，牙龈浮肿而头汗出也。舌红苔净，脉弦而细，皆为热伤阴血之征。

治法：滋阴清热。

方药：甘露饮加减。

茵陈20克，黄芩6克，天冬10克，麦冬10克，白芍10克，生地 12克，石斛15克，沙参10克，丹皮10克，枳壳6克，枇杷叶6克。

方义：此足阳明、少阴药也。烦热多属于虚，故以二冬、生地、石斛、沙参以滋阴清热，泻而有补；茵陈、黄芩之苦寒，清热利胆而治黄疸；丹皮、白芍平肝凉血；火热上行为患，故又以枳壳、枇杷叶抑而降

之也。

热愈盛则阴愈伤，“燥胜则干”，阴伤则燥甚，燥亦可发黄，《金匱要略》云：“诸黄，猪膏发煎主之”，即此之意。

【案例】

李某，男，55岁。患慢性肝炎，身体倦怠无力，右胁胀痛不适，肝功能化验，转氨酶为380单位，总胆红素21.2毫克，胆红素16毫克，周身黄疸如烟熏，小便深黄而短，两足发热，抵出被外为快，脘腹微胀，齿衄，口咽发干，脉弦细数，舌绛少苔，头有汗而身无汗。辨为湿热伤阴，津液不滋之证。治当清热利湿，并养阴液。疏方：茵陈蒿30克，黄芩6克，石斛15克，生地12克，麦冬10克，天冬10克，枳壳6克，枇杷叶6克，沙参10克。此方服八剂，胆红素降至10毫克，因其衄血不住，又加白茅根30克，广角3克，服六剂，胆红素降至5.1毫克，后又改用柴胡解毒汤而转氨酶逐渐下降，继而服药约百剂，其病获愈。

【按语】

湿热黄疸而见湿热伤阴之证，临床辨治颇为棘手。欲养阴又恐恋湿热，欲清利湿热又恐伤其阴。因此，必须做到：养阴而不膩，清化而不苦寒，半补半清，徐徐缓图，或可收效。

五、瘀血黄疸

症状：黄疸呈黧黑色，色气黯滞，目青面黑，少腹满，额上黑，大便黑而时溏，舌质尖红苔黄腻，脉沉弦而涩。

证候分析：瘀血黄疸，色泽黯滞而黧黑，面黑、额上黑，此《金匮要略》所论女劳疸或黑疸之属，目青系肝郁所致，肝郁不舒则少腹满；肝郁脾虚，则大便黑而时溏，舌质尖红苔黄腻，系湿热内蕴之象，脉沉弦而涩乃瘀血之征。

治法：行瘀化湿。

方药：硝石矾石散加味。

火硝10克，皂矾10克（皆烧存性），虎杖15克，丹参30克，茜草15克，田三七12克。共为细末，每日早、中、晚各服4.5克。

方义：方中以皂矾之酸咸，硝石之苦咸，润下而荡涤热结，消瘀逐浊之功甚速。虎杖、丹参、茜草、田三七，意在消瘀，佐以清热化湿，对瘀血所致黄疸皆有较好疗效。

【案例】

经闭三月，膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑，足下热，大便色黑，时结时溏，纳少神疲，脉象细涩。良由寒客血脉，宿瘀不行，积于膀胱少腹之间也，女劳疸之重症，非易速痊。古方用硝石矾石散，今仿其意，而不用其药。当归尾，云茯苓，藏红花，带壳砂仁，京赤芍，桃仁，肉桂末，西茵陈，丹参，青宁丸，血余炭，泽泻。（《清代名医医案精华·丁甘仁医案》）

【按语】

本案原有经闭，宿瘀不行，继而成为女劳疸，丁氏用硝石矾石散法，而另制其方，是善用古法者。张锡纯审定硝石矾石散，用治内伤黄

疸，是皆热与瘀结，瘀而不行所致，亦可师法。

六、疫毒黄疸

症状：卒然身黄，黄色如金，迅速加深，心满气喘，高热口渴，腹胀胁痛，严重时神昏谵语，烦躁，尿如柏汁，或吐血衄血，身见斑疹，舌红绛苔黄燥，脉弦数或细数。

证候分析：本证又名瘟黄，缘由“天行疫疠”，“时行热毒”感染而成，具有发病急、病势重的特点。而感染疫毒，肝胆失其疏泄，故有卒然身黄、黄色如金、高热口渴、心满气喘等症。肝与心包同属厥阴，疫毒深陷营分血分，因肝病及心包，瘀与热相搏，故烦躁、神昏谵语、吐血衄血、身见斑疹。舌红绛苔黄燥，脉弦数或细数，皆为热毒伤阴之征。

治则：清热解毒，凉血散瘀，佐以清心开窍。

方药：犀角地黄汤合清营汤加减。

犀角粉2克（另冲），水牛角末6克（分冲），生地黄20克，丹皮10克，赤芍10克，银花15克，连翘15克，元参15克，麦冬12克，茵陈15克，栀子10克，大黄10克，送服安宫牛黄丸1粒。

方义：方中以犀角地黄汤清营凉血化瘀，清营汤清透营分邪热，合茵陈蒿汤清热泻下，送服安宫牛黄丸清热开窍醒神，因而使疫毒解，黄疸消退。

《沈氏尊生书·黄疸》指出“又有天行疫疠，以致发黄者，俗称之瘟黄，杀人最急。”《诸病源候论》列“急黄候”，并云：“有得病即身体面目发黄者，有初不知是黄，死后乃身面黄者，其候得病但发热心战者，是急黄也。”急黄可能相当于现代医学所指的急性传染性肝炎、急性肝坏死、肝性昏迷等病范围，迄今疗效不高，是值得研究的课题。据报道：有用大剂量清热解毒，清营凉血，清心开窍而获得治愈的案例。我们认为本病的防治应注意：①抓紧早期治疗，早期正气尚盛，运用清营凉血与清热解毒相结合，往往可以阻断其恶化趋势；②在治疗中要权衡攻邪与养阴的关系，既要清利湿热，又要谨防阴竭；③恰当使用攻下法，逐邪从大便而出往往较利小便为速，迫邪从粪解，实火下降，可使源流清而神志苏。

七、寒湿黄疸

症状：黄色晦暗，汗出身冷，食少纳呆，腹胀脘闷，大便溏，小便不利，舌质淡，苔白腻，脉沉迟。

证候分析：脾胃寒湿，中阳不运，寒湿阻滞中焦，肝胆气机不畅，胆液外溢，故身目黄而晦暗，食少纳呆。脾失健运，寒遏阳虚，故腹胀脘闷，便溏。脾肾阳虚，故汗出肢冷。阳虚而膀胱气化不行，故小便不利。舌质淡，苔白腻，脉沉迟，为阳虚而湿浊不化之象。

治法：温阳化湿。

方药：茵陈五苓散加附子、干姜。

茵陈30克，茯苓15克，泽泻10克，白术30克，桂枝10克，猪苓10克，附子10克，干姜6克。

方义：方中以茵陈退黄，二苓、泽泻淡渗利湿，白术健运脾土，附子、干姜温脾肾之阳，桂枝化气行水，共奏温阳化湿之效。

【案例】

姜某，男，26岁。久居山洼之地，遇春雨绵绵而入山中作业，久雨湿衣，劳而汗出，雨水汗水共渍，遂成黄疸。前医用清热利湿退黄之剂，经治月余，毫无少效，几欲不支。就诊时，黄疸指数85单位，转氨酶高达500单位。察其全身黄而晦暗，颜面色泽晦滞而垢，看其苔白腻，舌质淡，诊其脉沉而迟，问其二便，大便溏，日二、三次，小便甚少。全身似虚肿，神疲而短气，无汗而身凉，遂辨为寒湿阴黄，治宜温阳化湿利黄，守茵陈五苓散加附子、干姜汤，初则日进二剂，三天后诸症好转，续日服一剂，三周痊愈，化验检查亦正常。

【按语】

阴黄之作，或外受寒邪，内伤生冷，或医过用寒凉，伤脾害胃。本案患者恃年轻以雨水劳倦于不顾，自受寒湿，继则医用寒凉误治，以致寒湿发黄。所幸者温阳化湿之后，即有效验，堪称应手。

肝病湿热诸毒黄疸的辨治已知前述，临床运用时要灵活掌握。①要分清先后、缓急、轻重。邪盛以祛邪为主，或因势利导，从大小便利之，挟表者汗之；正虚以扶正为主，湿热伤阴则易，宜扶阴为要，寒湿伤阳为急，宜温化是务。②要根据初、中、末不同时期，运用不同方法。初期邪盛正不虚，祛邪即所以扶正；中期邪正交争，宜祛邪兼以扶正；晚期正不胜邪，则以扶正为主；寒热夹杂，阴阳错综，虚实混淆，则要随机制方以应变。③要把握疏肝与清利的关系。尤其湿热患者，若兼顾疏肝，则疗效更速。④要谨防转化。湿遏热伏过久，或邪从体化，或误用寒凉，可使阳黄转成阴黄，治疗不可一成不变。

值得指出的是：《伤寒论》和《金匱要略》两书对黄疸的论述均有较大的实用价值。《伤寒论》论“伤寒发黄”，按时行病论治，可能就包括了肝病黄疸的辨治，全书论黄疸约计十八条，独茵陈蒿汤和栀子柏皮汤为治黄独树一帜，实起到了启示后学的作用。《金匱要略》论黄疸二首，脉证十四条，方七首，其中有审小便利与不利，辨黄之发与不发，审口之渴与不渴，辨疸之易治难治，皆有一定道理，对临床极为有用。我们应当在继承前人宝贵遗产的基础上，继往开来，大胆创新，更好地为人民保健事业服务。

第七章 气血瘀滞证治

肝司气机，藏血之脏。肝病初伤在气，继而气病及血。在一定的病理阶段，多表现出气血瘀滞之症，或伤经，或入络，种种见证不一。

一、肝血瘀滞

症状：面色青黑不华，右胁作痛如针刺，尤以夜晚为甚，或伴有腹胀，体倦无力，肝脾肿大，手可触及，脉弦而涩，舌绛，边有瘀斑，苔白。

证候分析：气病及血，血脉瘀阻，故肝区刺痛，而夜晚尤甚。肝脾肿大，脉弦而涩，以及舌有瘀斑出现，反映了肝血瘀滞之势已成。

治法：疏通气血，软坚消痞。

方药：加味柴胡桂枝汤。

柴胡12克，黄芩6克，党参9克，炙甘草6克，半夏9克，生姜9克，鳖甲15克，牡蛎15克，红花9克，茜草9克。

此方以十剂为一疗程，轻者两个疗程，重者四个疗程，即可收明显效果，临床用于治疗早期肝硬化也颇为理想。

方义：本方即小柴胡汤去大枣，加鳖甲、牡蛎、红花、茜草而成。以小柴胡汤疏通气血，和解表里，加鳖甲软坚，牡蛎消痞，红花、茜草活血。其用量柴胡应大于党参、炙甘草一倍，疗效才明显可靠。

【案例】

湖北，王某之妻，患慢性肝炎，日久不愈，已至“早期肝硬化”阶段，胁痛如刺，日轻夜重，脉来弦涩，舌质紫暗，边见瘀斑。问其月

经，则称四十天一次，经行少腹疼痛颇剧。辨为肝病日久不解，气病及血，肝络血瘀之证。

遂用：柴胡10克，桂枝6克，黄芩6克，白芍6克，红花10克，茜草根 10克，丹皮10克，坤草10克，土鳖虫6克，炙甘草6克，党参6克，半夏6克，生姜6克，鳖甲20克，牡蛎20克。

此方前后共服30余剂，则胁痛不作，月经按时而来，饮食增加，面容光洁，判若两人，从此肝病痊愈。

二、肝血瘀而有腹水

血可化水，水可化血。肝病过程中，水血互结而瘀，或胀、或痛、或肿，但有阳虚阴虚之别。

（一）水结互瘀

症状：面色黧黑，腹部青筋暴起，四肢反瘦，小便发黄而不利，舌质紫暗，脉沉弦。

证候分析：由于血瘀气阻，导致水湿内聚，而小便不利，腹胀满青筋暴起，舌质紫暗，反映脉络瘀阻，脉沉弦则主水湿已凝而不消散。

治法：消满除湿，活血逐水。

方药：消胀除湿汤。

郁金10克，木瓜6克，苡仁30克，蜣螂10克（炒，去翅足），路路通15克，丝瓜络10克，佛手12克，香橼皮12克，茯苓皮15克，冬瓜皮15克，枳壳6克，紫菀6克。

方义：此方用蜣螂入阳明、厥阴二经，消腹胀，行血气；路路通通经利水，木瓜伐肝利湿，苡仁利水湿之滞；郁金行气血之瘀，丝瓜络活血通络；茯苓皮、冬瓜皮利水消胀；枳壳行气宽中，紫菀利肺宽胸，两药相配，能消气滞之腹胀；佛手、香橼皮疏肝利气，能开水气之凝结。

【按语】

此方治肝硬化腹水而不太严重者，一般多有效。

（二）阳虚气滞，血瘀水停

症状：腹胀大，按之不坚，胸腹满，面色晦滞，畏寒肢冷，下肢浮肿，舌质淡紫有齿痕，苔薄白，脉弦细，甚则呕血吐血。

证候分析：脾肾阳虚，水饮搏结于胸腹，阴寒内盛，是以腹胀大，按之不坚，胸满，畏寒肢冷；气聚水停血瘀，故下肢浮肿；肝血瘀阻，故面色晦滞，舌质淡紫；瘀甚则迫血，故呕血吐血。脉弦细，苔薄白，皆阳虚肝郁之征。

治法：温阳活血利水。

方药：桂枝去芍药加麻辛附子汤加减。

桂枝12克，麻黄10克，生姜12克，甘草6克，大枣6枚，细辛6克，附子10克，丹参30克，郁李仁30克。

方义：方中用桂枝汤去芍药之酸寒，配麻黄附子细辛汤，通阳补中，逐饮散寒，丹参活血化瘀，郁李仁通便行水。

【案例】

丁某，男，43岁。胁痛3年，腹鼓胀而满3月，经检查诊为“肝硬化腹水”，屡用利水诸法不效。就诊时见：腹大如鼓，短气撑急，肠鸣漉漉，肢冷便溏，小便清长而量少，舌苔薄白质淡，脉沉细，诊为阳虚气滞，血瘀水停。拟桂枝去芍药加麻辛附子汤加味：桂枝10克，生麻黄6克，生姜10克，甘草6克，大枣6枚，细辛6克，熟附子10克，丹参30克，白术10克，三棱6克。

服药30余剂，腹水消退，诸症亦减轻，后以疏肝健脾之法，做丸善后。

【按语】

桂枝去芍药加麻辛附子汤，原载《金匮要略·水气病脉证并治》篇，原文云：“气分心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作，桂枝去芍药合麻辛附子汤主之。”陈修园颇有所悟地解释：“此方略露出其鼓胀机倪，令人寻译其旨于言外”。该方重在桂枝去芍药以温肝，麻黄附子细辛汤鼓舞肾阳，使“大气一转，其气乃散”。临床可加用牛膝、益母草、沉香、槟榔、丹参等活血利水之品，待腹水消退后，应健脾利水以善后。

（三）阴虚内热，血瘀水停

症状：腹大胀满，手足心热，低热，面色萎黄，消瘦乏力，两颧泛红，口干口苦，齿衄鼻衄，小便黄短，大便溏，或便解不畅，纳差，胸背可见蜘蛛痣，舌质红绛少津，脉弦细而数。

证候分析：肝病营阴受损，阴虚内热，脾病转输失常，运迟则水湿蕴郁，肝脾两伤，统藏失职。肝阴不足而内热，故见手足心热，低热，两颧泛红，口干口苦，舌质红绛少津；脾不转运，故小便黄短，大便溏，纳差神疲；气滞血瘀，故胸背泛见蜘蛛痣；脾虚水停，故腹大胀满，内热迫血妄行，故齿衄鼻衄。

治法：养阴活血利水。

方药：养阴活血利水汤。

生地30克，何首乌20克，玉竹15克，赤芍12克，丹皮10克，胆草6克，鸡内金9克，茅根30克。

方义：方中以生地滋阴，首乌养血，玉竹增液，赤芍、丹皮凉血化瘀，胆草泻火，鸡内金软坚，白茅根清热凉血利水，从而共奏滋阴利水之效。

【案例】

查某，男，45岁。患血吸虫病肝硬化多年，近二月来，腹渐胀大，腹皮绷急而光亮，腹形如箕，欲便不能，欲溲不得，纳差，时泛恶，齿龈出血，体酸，口干口苦而黏，舌质红绛苔净，脉细弦而数，诊为阴虚血瘀成癥，水血互结。拟养阴活血利水汤增损：生地45克，何首乌20

克，玉竹15克，赤芍12克，丹皮10克，丹参30克，鸡内金6克，白茅根30克，益母草15克，郁李仁10克。

服六剂而腹水明显消退，腹胀减轻，继服三十剂，舌仍绛，但有薄苔，诸证亦见好转，后改汤为丸，巩固三月，渐趋平稳。

【按语】

养阴活血利水汤，用治阴虚型肝硬化腹水，有明显利水之效。《医碥》云：“气血水三者，病常相因，有先病气滞而后血结者，有先病血结而后气滞者，有先病水肿而血随败者，有先病血结而水随蓄者。”说明气、血、水三者常互为因果，是形成肝病臌胀、腹水恶性循环的主要原因之一。水可化血，血可化水，水赖气化，气赖血载，津液精血皆由水谷所化。若阴虚内热，阴虚水停，阴虚血瘀，皆可导致腹水成臌，治宜滋阴为主，佐以活血利水。我们在临床上体会到，阴虚水停患者，运用生地、首乌，不但无泥膈之弊，而且必须重用才能收功，常可收到滋阴而不碍水，利水而不伤阴之效，故附录于此，以供读者参考。然阴虚型肝硬化腹水，其预后多属不良。

三、肝脾之积

《难经·五十六难》云：“肝之积名曰肥气，在右肋下如覆杯，有头足……脾之积名曰痞气，在胃脘，覆大如盘。”古之“肥气”、“痞气”，即相当于今之肝脾肿大。由于肝病由气及血，继而病水，故在气分则痞，在血分则癥，病水则成臌。肝脾肿大未至水停，应按气滞血瘀论治，其证治规律有：

（一）阴虚内热，气血凝滞

症状：肝脾肿大疼痛，夜晚尤为明显，腹胀，口咽发干，面黑，或五心烦热，或低烧不退，舌红少苔，边有瘀斑，脉弦而细。

证候分析：肝脾肿大疼痛，舌有瘀斑，乃气血瘀滞之象；腹胀为气滞，肝脾不和所致；口咽发干，主津液已伤；五心烦热，或低烧不退，是阴虚内热之候。

治法：滋阴软坚，活血化瘀。

方药：柴胡鳖甲汤。

柴胡6克，鳖甲15克，牡蛎15克，沙参10克，麦冬10克，生地10克，丹皮12克，白芍12克，红花9克，土鳖虫6克。

方义：方中以沙参、麦冬、生地以益胃阴，胃阴复而气降得食，则肝阴自可复。丹皮凉血，白芍护肝阴，牡蛎软坚，鳖甲软坚通络，柴胡疏肝，红花、土鳖虫活血化瘀，从而可达软缩肝脾之效。

【案例】

李某，男，35岁。患慢性肝炎已有两载，肝脾肿大且疼，胃脘发胀，暖气少舒，口咽发干，饮食日减，自述服中药二百余剂，迄无功效，索视其方，皆香燥理气之品，其脉左弦细，右脉滑，舌光红无苔。证候分析：服药二百余剂不为不多，然无效者，此肝胃不和，而非一般

之肝胃不和，何以知之，舌红而光，脉又弦细，口咽又干，阴虚乏液昭然若揭。且新病在经，久病入络，宜乎肝脾肿大而又疼。治法：软坚活络，柔肝滋胃。方药：川楝子10克，鳖甲20克，生牡蛎15克，红花6克，茜草10克，麦冬12克，玉竹12克，生地15克，丹皮9克，赤芍9克。

此方加减进退，服至三十余剂，胃开能食，胁胀与疼皆除，面红润，逐渐康复。

【按语】

据我们临床体会：此方治疗慢性肝炎晚期，出现蛋白倒置，或乙型肝炎“澳抗”阳性者，或亚急性肝坏死，而出现上述脉证时，多有较好功效。

（二）湿热伤肝，血瘀成癥

症状：胁下痞块，坚硬不移，胁肋胀痛，腹胀，纳差，四肢浮肿，溲黄短，便溏，舌暗苔白腻，脉弦细，或濡数。

证候分析：肝胆脾胃协调机体气机升降活动，以为生理之常。若湿热壅滞肝胆，肝胆失其疏泄，以致脾不升清，运化无权，湿热壅滞愈甚，肝胆气血瘀滞愈剧，上不得入，下不得出，中不能透达，是以胁下痞块，坚硬不移，胁肋胀痛，继而腹胀、纳差、便溏、浮肿、溲黄而短。舌暗主血瘀，苔白腻主湿不化，脉弦细主肝气郁滞，脉濡数主湿热壅滞。

治则：辛开苦降，佐以活血消癥。

方药：加减痞气丸。

川厚朴60克，黄连60克，干姜60克，茵陈60克，茯苓90克，猪苓60克，泽泻60克，党参60克，苍术60克，丹参60克，砂仁30克，黄芪60克，三棱60克，莪术60克，鳖甲90克，青矾60克，卷柏60克，青陈皮各60克，神曲60克。

共研细末，水泛为丸，每日早、中、晚各服9克。

方义：本方从痞气丸加减而成。方中以参芪苓术益气健脾燥湿，以

茵陈、茯苓、泽泻利水，黄连、干姜辛开苦降，青陈皮、砂仁、厚朴、神曲理气导滞，鳖甲入络搜邪，青矾敛_清燥湿，卷柏、丹参凉血化瘀，尤妙在三棱、莪术消积化瘀，张锡钝说：“三棱、莪术能治一切血凝气滞之症，若与参术芪诸药并用，大能开胃进食，调血和血。”本方作用特点：助脾胃以调升降，辛开苦降以调寒热，益气活血以消癥积。

【案例】

景某，男，37岁。患血吸虫病肝脾肿大3年，屡用锑剂注射治疗三次，肝脾未见明显缩小，近三月来，胁胀满痛，腹胀，颜面清瘦，下肢轻度浮肿，纳差，便溏，舌暗苔白根腻，脉弦细，自叹不久人世，乃求余予之一决。余诊为癥瘕，湿热伤肝，血瘀所致，照加减痞气丸原方，共服三料，竟体丰神健，肝脾亦见缩小，随访十余年未见复发。

【按语】

据笔者临床体会，加减痞气丸对血吸虫病肝硬化而见上症者，具有较好疗效。

（三）寒热错杂伤肝，血瘀成癥

症状：左胁下板滞，积块不移，纳食不舒，食后腹胀，舌质淡，苔白腻，脉濡或_清。

证候分析：肝从左而升，肺从右而降。邪聚肝络，气血凝滞，是以左胁下板滞，积块不移，即是脾肿大，皆气结血瘀所致。脾寒而不运，是以纳食不舒而苔腻；木郁而为热化，继而克脾，是以腹胀；脉濡为脾湿，脉_清主血瘀，皆为或见之脉。

治法：活血消癥，寒热并调。

方药：鳖甲煎丸。

炙鳖甲120克，乌扇30克（即射干，烧），黄芩30克，柴胡60克，鼠妇30克，干姜30克，大黄30克，白芍50克，桂枝30克，葶苈10克（熬），石韦30克（去毛），厚朴30克，丹皮50克（去心），瞿麦20克，紫葳30克，阿胶30克（炒），蜂窝40克（炙），赤硝60克，蜣螂60克（熬），桃仁20克，半夏10克，人参10克，廔虫50克（熬）。

共为末，依法蜜丸，每日二次，每次6~9克。

方义：本方扶正之中，寓辛苦通降，咸走血络法。方中鳖甲为君，主癥瘕寒热，专入肝经血分，引四虫入脏络。四虫者，廔虫、蜣螂、鼠妇、蜂房，取其迅速飞走入络，以松透病根，即行络中之气，又化络中之血。辅以桃仁、丹皮、紫葳破满行血，以葶苈、石韦、瞿麦行气渗湿。尤妙在以小柴胡汤合桂枝汤去姜枣，既调营卫，又和解少阳；大承气去枳实，驱胃腑之热结，三阳同治，佐以人参、干姜、阿胶补益气血以养正，因而用治癥瘕疟母，肝脾肿大而见上证者，均有较好效果。

【案例】

沈左，久疟屡止屡发，刻虽止住，而食入不舒，左胁按之板滞，胃钝少纳，脉濡，苔白质腻，脾胃气弱，余邪结聚肝络，拟和中运脾疏络。於潜术炒二钱，陈皮一钱，川朴一钱，制半夏一钱五分，沉香曲一钱五分，焦楂曲三钱，茯苓三钱，炒竹茹一钱，鳖甲煎丸一钱五分，开水送服。（《张韦青医案》）

【按语】

鳖甲煎丸虽然重点是在理气血破瘀消结，且有和解表里、平调寒热、通利上下之功，但犹恐药性猛峻，宜辅以调理脾胃，运行气血等养正之药。本案系以运脾疏络和中，送服鳖甲煎丸，临床可广泛用于肝脾肿大而见症如上者。不过，本方与“缓中补虚”的大黄廔虫丸相比较，其化瘀之力则明显逊于大黄廔虫丸，而养阴之力反而较强。

（四）燥淫伤肝，血瘀成癥

症状：腹中癥块不散不痛，或胁痛寒热，或妇女痛经，经闭，或产后血瘀。

证候分析：肝肾阴伤，妄用急攻治癥，致癥成蛊。肝气郁滞，燥邪深入下焦血分，是以腹中癥块不散不痛，或兼见胁痛寒热。妇人以肝为先天，故见痛经、经闭、产后血瘀诸症。

治法：消癥破结，润燥回生。

方药：化癥回生丹。

人参（或党参代）90克，安南桂30克，两头尖30克，麝香20克，片姜黄30克，公丁香45克，川椒炭30g，苏木45克，桃仁45克，苏子霜30克，五灵脂30克，降真香30克，干漆30克，当归尾60克，没药30克，元胡索30克，白芍60克，杏仁45克，香附米30克，吴茱萸30克，水蛭30克，阿魏30克，小茴香炭30克，川芎 30克，乳香30克，良姜30克，艾炭30克，益母膏120克，熟地黄60克，鳖甲胶30克，大黄120克。

共为细末，以鳖甲、益母、大黄三胶和匀，再加炼蜜为丸，重5克，蜡皮封，用时温开水和，空心服，瘀甚之证，黄酒下。

方义：“燥淫于内，治以苦温”。本方系从鳖甲煎丸、回生丹脱胎而出。吴鞠通自谓：“此方以参桂椒姜通补阳气，白芍、熟地守补阴液，益母膏通补阴气而消水气，鳖甲胶通补肝气而消癥瘕，余俱芳香入络而化浊，且以食血三虫，飞者走络中气分，走者走络中血分，可谓无微不至，无坚不破，又以醋熬大黄三次，药入病所，不伤他脏，久病坚结不散者，非此不可。”

【案例】

乙酉八月三十日，王室女，二十岁，肝郁结成癥瘕，左脉沉伏如无，右脉浮弦，下焦血分闭塞极甚，此干血癆之先声也。急宜调情志，切戒怒恼，时刻能以恕字待人，则病可愈矣。治法以宣络为要。

新绛纱三钱，桃仁泥三钱，广郁金三钱，苏子霜三钱，旋覆花三钱（包），归横须三钱，降香末三钱，公丁香一钱五分，煮三杯，分三次服。

九月初四日，服前药四帖，六脉沉伏如故，丝毫不起。病重则药轻，于前方内加川椒炭三钱，良姜二钱。

再用化癥回生丹早晚各服一丸，服至癥瘕化尽为度，三、四百丸均未可定，断不可改弦易辙也。

十月十七日，癥瘕瘀滞，服宣络温经药二十二剂，化癥回生丹四十余丸，业已见效不浅，脉亦生动，经亦畅行。药当减其制，化癥回生丹每早空心只服一丸，效则不必加，切戒生冷猪肉介属，可收全功。

新绛纱三钱，丹皮五钱，广郁金二钱，香附三钱，旋覆花三钱（包），归横须二钱，降香末二钱，广皮二钱，苏子霜一钱五分，煮三杯，分三次服。此方常服可痊愈。（《吴鞠通医案》）

【按语】

本案患者，年方弱冠，肝郁成癥，血分闭塞已极，先予宣络，继佐温通，并加服化癥回生丹，始效，脉由“沉浮如无”，以致“生动”，月经由闭而畅行，进而痊愈。病程中加用化癥回生丹，要求服至癥瘕化尽为度，断不可改弦易辙，可见，化癥回生丹之功甚伟。

化癥回生丹较鳖甲煎丸似力峻而实稍缓，不仅人参、地黄、鳖甲胶用之量大，加以醋蜜为制，峻者亦为缓也。无怪吴氏自信地说：“有制之师不畏多，无制之师少亦乱也。”

综上所述，肝瘀血而腹水，或肝脾肿大，皆系渐变而成，缘因情志郁结，肝失疏泄，或饮食失节，脾胃受伤，或黄疸病后，或感染诸虫等因素引起，继而气滞、血瘀、水停。始于气滞，终必血瘀，发展则水聚而成臌胀，病位多由肝脾而累及于肾。其证治皆以气滞血瘀为标实之证，以阳虚内寒，或阴虚内热而为本，因阳虚多气化不行而停水，阴虚多精血同亏而内热，因而治疗宜标本兼顾，或温阳益气活血利水，或滋阴养血清热化瘀，皆宜据证而施，自始至终，不可攻伐太过，亦不可操之过急，不可辛燥温补太甚而愈增其胀，《格致余论》云：“医者不察病起于虚，急于作效，炫能希赏，病者苦于胀急，喜行利药以求一时之快，不知宽得一日半日，其胀愈甚，病邪甚矣。”因而，正确运用扶正祛邪之法，是取得疗效的关键。

四、肝着

症状：胸胁胀满刺痛，痛处不移，吞酸作呕，口渴欲热饮，得热饮稍舒，舌质暗紫，脉细涩。

证候分析：肝着是指肝脏气血郁滞不行，逆而犯肺而言，尤在泾说：“然则肝虽着而反注于肺，所谓横之为病。”（《金匱要略心典》）肝郁而横逆于肺，是以胸胁皆胀满刺痛，痛处不移；犯胃则吞酸作呕；气血遇寒则滞，得热则舒，瘀阻于内，是以口渴欲饮，得热饮则舒。舌质暗紫，脉细涩，皆血瘀之征。

治法：行气散滞，通阳和血。

方药：旋覆花汤加味。

旋覆花10克（包煎），茜草10克，葱白10克，合欢花10克，柏子仁10克，丝瓜络10克。

方义：方中以旋覆花咸温下气，散结而通血脉，葱白通胸中之阳，原方用新降，今用茜草代之，用以破血活血，合欢皮疏肝活血，柏子仁理气行滞，丝瓜络通络，从而使气血宣通，诸证可解。

【案例】

刘某，女性，24岁。情怀素抑郁而不舒，肝区疼痛而胀，胸满已二年，屡治乏效，逍遥、越鞠、四七诸汤皆不应病，近二日疼痛愈频，痛如针刺而不移，时呕吐痰涎，欲热饮而心胸宽以少许，舌质暗苔薄净，脉细弦，诊为肝着，投旋覆花汤加味：旋覆花10克（包煎），茜草12克，葱白三根，合欢皮12克，柏子仁10克，丝瓜络10克，当归10克。服药三剂，疼痛如失。

【按语】

旋覆花汤以旋覆花为君，降胸中之气而不破气，不同于枳朴之下

气；葱白通胸中之阳，不能等同于薤白、葱白轻宣，使阳气自通；茜草、当归皆活血之妙品，是以理气行气诸方不应，而用通阳和血，行气散滞始可收功。若肝着之病，郁久不愈，伤及肝络，可致肝络不和。

五、肝络不和

肝络不和，是肝病由气及血，瘀阻络脉所致，反映了病邪深居隐伏。临床可分为络实证和络虚证，虚实证治有别。

（一）络实证

症状：胁痛如刺，固定不移，卧着不安，剧则呼吸不利，腹胀，食则痛剧，脉涩。

证候分析：肝络凝瘀，或肝风内震入络，故胁痛如刺，固定不移。瘀重则气机壅滞愈甚，可见呼吸不利，卧着不安。阴邪聚络，或络脉瘀甚，可见腹胀，进食而痛剧。脉涩主血瘀也。

治法：辛温通络。

方药：辛香温通汤。

葶苈10g，半夏9g，川楝子9g，元胡6g，吴茱萸9g，良姜9g，蒲黄9g，茯苓10g，桂枝6g，当归须10g，淡姜渣6g。

兼血瘀痛久不移，邪正交结，可加^麝虫3克、蜣螂6克；若症属虚寒，可加枸杞6克、苁蓉10克、胡桃10克、鹿角霜9克。

方义：方中以葶苈、吴茱萸、良姜、桂枝辛温快利，佐以半夏、姜渣、茯苓化痰通络，伍以川楝子、元胡、当归须理气活血止痛，又防吴茱萸、桂枝辛燥太过之弊。全方配伍，可达辛香温通，活络止痛之效。

【按语】

本方对肋间神经痛而见症如上者，常有明显效果。

络实之证，是邪伏深居络脉，性质属实之证。因积伤入络，气血皆瘀，既不能峻攻，又不可缓图，必须辛香温通，燥动络中伏邪，络脉才能畅和。叶天士门人姚亦陶说：“阴邪聚络，大旨以辛温入血络治之。盖阴主静，不移即主静之根，所以为阴也，可容不移之阴邪者，自必无阳动之气旋运之，而必有阴静之血以倚伏之，所以必藉体阴用阳之品，方能出阳，以旋其辛散温通之力也。”（《临证指南医案·积聚》）若瘀血久滞，邪正交结，宜“取虫蚁迅走飞去诸灵”，以达“松透病根”之效，故加**麋**虫、蜣螂为妥，若络虚寒者，宜温润通补，所谓“柔剂阳药”，如鹿角霜、枸杞、苡蓉、胡桃等，通奇经络脉而不滞，温补血络而不凝，非一般补血厚味之品所能比。

络实证有轻重之别，治有缓急之分。叶天士治络实证，主张辛润法，宜于邪在络久而化热化燥的患者，以旋覆花汤加归尾、桃仁、红花、柏子仁等；若剧者配伍和阳益阴，润滑善动之品，如生地、阿胶、麻子仁等；若有热者，加辛凉润而又善走之品，如川楝子、丹皮、夏枯草等。与前述辛香通络法相比，本证较前为轻，治亦稍缓。

（二）络虚证

症状：胁痛悠悠，痛不持久，重按少缓，得食自缓，知饥不纳，唇紫，舌青，脉细涩；或身寒，呕吐清涎，或入阴分势笃，五心烦热。

证候分析：虚为气血不足，肝络不荣，故“络虚则痛”，凡虚者，病势不甚重，重按、得食能缓，若寒入络虚，是以身寒，犯胃则呕吐清涎；若络热则痹，每天夜甚，且兼五心烦热、唇紫、舌青、脉细涩，皆为瘀阻络道之征。

治法：柔剂通补。络虚寒则温柔辛补，络虚热则凉润辛补。

方药：

1.温柔辛补 宜当归生姜羊肉汤。

当归15克，生姜15克，羊肉60克。

2.凉润辛补 宜炙甘草汤去姜桂。

炙甘草12克，大枣10克，麦冬12克，火麻仁10克，生地12克，阿胶10克。

方义：温润辛补方，以当归、生姜之辛，养血散寒，羊肉温补养

血，是以有通补之功。凉润辛补方，麦冬、阿胶、生地养阴益血，炙甘草温通益气，火麻仁凉润，大枣扶脾益气，是以有凉润辛补之功，宜于液亏风动，络虚则热诸证。

【按语】

肝络不和，多是“药所不及”，深居而隐藏之处患病，有虚实不同病变规律。有病证特殊，病情缠绵，一般药难能取效，芩连不能清，姜附不能温，参芪不能补，芍地嫌其腻等特点。无论虚实，用药应取流动活泼之品，补应通补，攻应缓攻，这是病久入络的论治规律，临床应加以注意。

六、肝寒血凝经脉

症状：肩臂疼痛，得温则减，形寒，手足厥冷，舌淡而暗，脉细欲绝。

证候分析：肝虚而寒，寒邪客于血府，络脉不通，是以肩臂疼痛，得温则减。血虚不能充脉，阳气不能通达，故手足厥寒，脉细欲绝。形寒，阳虚之征；得温则减，虚寒之象。舌淡而暗，气虚凝瘀所致。

治法：温肝散寒，活血通脉。

方药：当归四逆汤加味。

当归9克，桂枝9克，赤芍药9克，细辛6克，炙甘草4.5克，木通6克，大枣6枚，葱白3根，陈绍酒30克。

方义：寒伤厥阴经脉，寒凝血瘀，故用当归四逆汤温肝经经脉之寒，活厥阴心包之血脉。该方为桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、木通、细辛组成。一方面寓治肝五法于一方之中，“以桂枝之辛以温肝阳，细辛之辛以通肝阴，当归之辛以补肝，甘枣之甘以缓肝，芍药之酸以泻肝，复以通草利阴阳之气，开厥阴之络。”（王晋三语）。该方再加入葱白、陈绍酒，取其速通经隧，畅通络脉。若其人内有久寒者，加吴茱萸直温厥阴之寒，生姜之辛以温散经脉之寒湿，从而畅通气血，温经散寒。王旭高云：“此方治寒入营络，腰腿足痛甚良”。

【案例】

少腹久痛未痊，手足挛急而痛，舌苔灰浊，面色不华，此寒湿与痰，内壅于肝经，而外攻经络也，现在四肢厥冷，宜当归四逆汤加减：当归（小茴香炒）、白芍（肉桂炒）、木通、半夏、苡仁、防风、茯苓、橘红。《曹仁伯验案》

【按语】

寒伤厥阴有在经、在络、在脏之别。伤经因厥阴血虚寒郁，伤络因络脉瘀阻，唯伤脏证最重，厥阴相火内寄，不易伤脏，若见脏寒之证，则生死攸关。本案少腹久痛未痊，手足挛急，四肢厥冷，显系肝血内虚，寒湿外犯，挟痰内壅肝经所致，故遵当归四逆汤法，去甘枣甘壅，免滋腻之弊，去细辛免损及营阴，桂枝改为肉桂，以温下焦之寒。半夏、橘红、茯苓、苡仁化痰利湿，防风祛风化湿，药后少腹痛止，惟手足挛急未愈，后转方专理上焦，以蠲痹汤去防风合指迷茯苓丸而痊愈。足见临床辨证，贵在灵活，法不变而方可变。

“人身所有者，血与气耳”，肝病无不关系气血，其体用矛盾失调的基本形式，就是气血失调，气滞血瘀则是这个基本形式的一个重要病理环节。前所述及的肝血瘀滞，肝血瘀而有腹水，肝脾肿大，肝着，肝络不和，肝寒血凝经脉等，皆是气滞血瘀中常见的病证，而每一病证又各有其不同证候特点，掌握这些证治特点和规律，就可以提纲挈领，提高临床疗效。

气滞血瘀的论治原则是：“疏其血气，令其调达，而致和平。”须知“阴血为病不犯阳气之药，阳旺则阴转亏也；阳气为病，不犯阴血之药，阴盛则阳转败也”。（《医宗必读·辨治大法》）因此，气血的偏胜或偏衰，不能脱离客观实际而存在，而治疗大法的侧重点也应随之相应变更，既掌握气血为病的共性规律，也应区别气血偏盛或偏衰致病的各自特点，从而进行恰当治疗。

第八章 寒热错杂证治

肝为厥阴，厥阴与少阳相表里，其中孕育着少阳升发的一阳之气。肝本身体阴用阳，藏阴贮血，而内寄相火，其为病或为寒伤而抑，或为阳气来复，从而寒热错杂之证尤多。现分述如下：

一、寒热错杂

症状：消渴，气上撞心，心中疼热，时烦躁，饥不欲食，食入则欲呕，或食则吐蛔。

证候分析：水亏于下，津液消耗见于上，故消渴；肝木横逆莫制，则气上撞心，心中疼热；蛔虫扰乱，故心烦，或食则吐蛔；脾阳不运于四肢，故手足厥冷；木横侮土，脾胃受病，故饥不欲食，食则欲吐。

治法：温清并用，制肝安胃。

方药：乌梅丸（《伤寒论》）加减。

乌梅12克（醋浸），细辛4.5克，干姜9克，黄连6克，当归9克，熟附子9克，桂枝9克，党参9克，黄柏9克，川楝子12克。

方义：本方即乌梅丸去川椒加川楝子而成。方中以醋浸乌梅，味酸入肝，能集敛诸药之力入肝补肝；伍以细辛、干姜，辛开理气，又能温通血脉；黄连、黄柏苦寒以清热；附子、桂枝温脏通脉；川楝子疏肝理气；党参、当归，一补气，一养血，气血同理。本方对肝病寒热错杂之证，具有交接阴阳之气而达厥愈热除之效。原方虽温清并用，但温药多而清药少，毕竟偏于温阳。去川椒后加入川楝子，则温清各半，于寒热错杂证尤宜。

【案例】

某，蛔厥心痛，痛则呕吐酸水，手足厥冷，宜辛苦酸治之。川连、桂枝、归身、延胡、乌梅、川椒、茯苓、川楝子、炮姜。（《静香楼医案》）

【按语】

本案呕吐酸水，手足厥冷，按蛔厥论治，仿乌梅丸之制，改丸为汤，取效迅速，于乌梅丸去附子、人参、黄柏、细辛，以炮姜易干姜，加入川楝子，不仅能增强杀虫作用，合延胡为金铃子散，尤擅治心胃诸痛，加茯苓淡渗，健脾利湿，足见尤氏不愧是善用古方者。

二、肝热脾寒

症状：口苦，心烦，胁痛连及背后，手指发麻，口渴，小便不利，大便不成形，每日两三次，腹胀满，尤以下午为甚，脉弦缓，舌淡苔白。

证候分析：肝胆有热则口苦心烦；脾有寒则大便不成形，而腹胀满；口渴、小便不利为气化不行，气不生津；胁痛绕背，手指发麻，为肝病气血不利之症；脉弦缓反映肝脾有病，舌淡为脾气虚。

治法：清肝温脾。

方药：柴胡桂枝干姜汤。（《伤寒论》）

柴胡12克，黄芩6克，炙甘草6克，花粉12克，桂枝6克，干姜6克，牡蛎12克。

方义：柴胡、黄芩清肝理气，桂枝、干姜温脾和中，花粉护阴，甘草益脾，牡蛎软坚，是以一方之中而有清肝温脾之效。

【案例一】

刘某，男，54岁。患肝炎而腹胀作泻，不欲饮食，胁痛及背，服药无效，某君请余为治，脉弦而缓，舌淡苔白，此乃肝病及脾，脾阳先衰

之象，为疏柴胡桂枝干姜汤：柴胡12克，黄芩4.5克，炙甘草9克，干姜9克，桂枝 9克，花粉12克，牡蛎12克。凡四服而腹胀与泻俱止，饮食较前为多，精神亦有好转，后以肝脾共调，佐以利湿之品，转氨酶日趋正常而告愈。

【案例二】

林某之母，54岁。左胁作痛，而大便溏薄，腹胀，口渴，屡治不效。切其脉弦缓无力，视其舌则淡嫩而苔白。辨为肝胆有热，而脾气复寒之证，乃投柴胡桂枝干姜汤。药后不但胁疼腹胀之病获效，而“糖尿”之病亦因之大减，因患者素有“糖尿”之疾，而诊时未言及，从此后，方知此方治糖尿亦有效。

【按语】

肝病疏泄失调，进而影响脾胃气机升降功能，可见呕吐、哕、下利诸证。前述两案均因肝热而疏泄不利，脾寒而运化失司，在肝则胁痛、口渴，在脾则腹胀便溏，故均以柴胡桂枝干姜汤获效。且无意中不治“糖尿”而糖尿病竟得“大减”，可见异病同治的机制在于病机之吻合。

三、上热下寒

症状：腹胀溏泄，食入即吐，或噎膈，或反胃，纳谷不馨。

证候分析：肝寓相火，相火妄动与寒气格拒交争，以致上热下寒，在上“食入即吐”，在下则腹胀便溏。噎膈、反胃皆为上热下寒之证。

治法：清上温下。

方药：干姜黄芩黄连人参汤。（《伤寒论》）

干姜9克，黄芩9克，黄连9克，人参9克。

方义：黄连、黄芩苦寒以清上热，干姜温脾以祛下寒，人参健脾补虚，以复中焦升降之能。本方寒热并用，苦降辛开，干姜又从其上热，

引导芩连入内，使之不发生格拒，是以温清并用。

总之，肝之为病，阴盛则寒，阳复则热，寒邪与阳复之热交争，是以寒热错杂。本章主要讨论寒热错杂，肝热脾寒，上热下寒几个主要证型，但临床上往往远不止此，我们已在有关章节中作了叙述，这里不再赘述。

寒热错杂的治疗，主要是温清并用，根据寒热孰多孰少，而分温、清偏重之治，凡此皆宜学者在临证之际，灵活权衡矣。

第九章 肝寒证治

肝寒证，是指感受寒邪，使肝脏气血凝滞，表现为四肢厥冷，腹痛，指甲青紫，脉象细弱或细沉欲绝等病证而言。《圣惠方》所谓“肝虚则生寒”，是因虚致寒，多因肝脏本身气虚或阳虚所致，与本章所讨论的肝寒证有虚实之别。

论治肝寒，应本着“寒者温之”的原则，治以温通之法，与治疗虚寒温养之法有别。现就常见的肝寒证分述如下：

一、肝寒浊阴上逆

症状：头痛，以巅顶为甚，干呕，或吐清涎冷沫，或吐利烦躁，舌质淡苔薄白，脉沉紧而弦。

证候分析：足厥阴肝经经脉与督脉会于巅顶，寒邪侵袭于肝，可见头痛，尤以巅顶为甚。寒伤厥阴，下焦浊阴之气上逆于胸胃，故干呕吐涎沫；胃阳不布，其涎沫清冷，甚则格拒而见烦躁，舌质淡苔薄白，气虚寒战之征，脉弦而沉紧主肝寒气滞。

治法：温肝散寒，降浊化饮。

方药：吴茱萸汤（《伤寒论》）加味。

吴茱萸9克，党参12克，生姜10克，大枣4枚，半夏10克，茯苓12克。

方义：方中以吴茱萸辛散苦降，温肝降逆，生姜辛散寒邪，人参、大枣甘温益气，且制吴茱萸、生姜之辛热燥烈，合半夏、茯苓降逆化痰涤饮。

【案例一】

刘木工，湖北人，一日至余寓求诊，云患呕吐清汁，兼以头痛不举，医者卒以风寒发散药，服之益剧，口中和，脉之沉，与吴茱萸汤，一剂知，二剂疾如失。（《遯园医案》）

【案例二】

车，脉沉弦而紧，呕而不渴，肢逆且麻，浊阴上攻，厥阴克阳明所致，宜急温之：台乌药10克，淡吴萸9克，法半夏10克，厚朴10克，萆薢6克，枳实10克，川椒炭10克，干姜10克，青皮6克，头煎两杯，二煎一杯，分三次服。（《名医类案》）

【按语】

前症肝寒而浊阴上逆，投吴茱萸汤即效，后案肝寒上逆，胃浊不降，仿吴茱萸汤法而不用原方，是为灵活变通，但两案皆以温肝散寒为宗旨，故投之皆效。细考吴茱萸汤，在《伤寒论》中凡三见：一见厥阴篇，“干呕吐涎沫，头痛”，显系肝寒及胃；二见阳明篇，“食谷欲呕，属阳明”，系胃寒气逆；三见少阴篇，“少阴病吐利，手足逆冷，烦躁欲死”，为少阴寒邪侮于脾胃，中气受邪则必影响阴阳上下相交之路，水火不济则烦躁欲死，故用温胃暖肝之法而取效。

二、寒滞肝脉

症状：少腹牵及睾丸坠胀疼痛，甚则阴囊收缩，受寒则甚，得热则缓，伴见形寒肢冷，舌苔白滑，脉沉弦或迟等。

证候分析：足厥阴肝经脉绕阴器，抵少腹，寒伤厥阴经脉，故少腹牵及睾丸坠胀疼痛；寒主收引，故痛甚则阴囊收缩，得冷反剧，得热则痛减。形寒肢冷，舌苔白滑，脉沉弦而迟，皆为寒滞肝脉之象。

治法：暖肝散寒。

方药：暖肝煎。

当归10克，枸杞10克，小茴香9克，肉桂6克，乌药12克，沉香4.5克，茯苓12克。

方义：本方的作用特点是，温通并用，温中有养。方中以肉桂、茴香温肝阳以散寒，枸杞、当归养肝血之虚，以乌药、沉香通肝气之滞，而又有暖肝之效，茯苓利湿通阳，兼治结气。

【案例】

一人病疝气，发则脐下筑筑，渐上至心下，呕涌痛急，手足青色，喉中淫淫而痒，眉间痛酸，目不欲视，头不欲举，神昏昏欲睡而不寐，恶食气，睾丸控引，小便数而短，年未三十，尪脊若衰耄人，劣劣不自持。诊其脉沉弦而涩，曰是得之扰，郁愤怒内因，寒湿风两乘之外因，为肝疝也，属在厥阴，故当脉所过之处皆病焉，厥阴肝也，张从正云：诸疝皆属肝，肝欲散，急食辛以散之。遂与吴萸佐以姜桂，及治气引经药，兼制茴练等丸，每十日一服利之，三月而愈。（《名医类案·疝瘕》）

【按语】

古人说：“七疝隶属于肝”，“治疝必先治气”。本案属疝气，投辛温散寒理气之剂而获效。

应当指出，寒滞肝脉有轻重之分，如当归四逆汤与暖肝煎乃是寒邪轻症，而大乌头煎则是寒邪重症，两者应加以鉴别。两者均以肝阳虚衰为共同的病理基础，但当归四逆汤、暖肝煎证偏少腹，寒邪较轻，故在温通之中佐以养血之药；大乌头煎宜于：腹部绕脐绞痛，五脏拘急，不得转侧，手足厥冷的寒疝重症，寒邪特甚，故用辛温大热之品，两者不难鉴别。

三、肝病腹胀而脾肾虚寒

症状：腹胀满，下肢肿，手足冷，大便作泻，小便少，饮食不振，

脉沉迟，舌胖而淡。

证候分析：脾虚寒湿不运，则腹胀作泻而小便不利；肾阳虚则肢冷、舌淡、脉沉，脾肾双虚，气化不利，则水肿不消。

治法：温补脾肾。

方药：加味实脾饮。

茯苓30克，木瓜6克，人参10克，白术10克，炙甘草6克，草蔻10克，大腹皮10克，厚朴6克，干姜10克，木香6克，炮附子10克。

方义：茯苓淡渗以利水，木瓜和肝脾以化湿，木香、厚朴、草蔻、大腹皮理气消胀，人参、炙甘草、白术、干姜温中扶虚以运化寒湿，附子气雄，补肾阳以消阴翳。

【按语】

据我们临床体会，凡慢性肝炎晚期出现肝硬化腹水等证，若伴有肝肾阴虚而有热的证候，脉弦劲有力而不衰，其预后多为不良；如伴有脾肾阳虚而有寒的证候，其治疗得法，则预后较好。黄芪、人参、附子的温阳扶虚之药用量可以略增，对改变蛋白倒置有明显的效果。肝硬化腹水是一个顽症，无论中医、西医对它的治疗都有一定的困难，主要问题在于腹水难下，使人憋胀难堪，如用逐水药大戟、甘遂、芫花、商陆、黑白丑，虽皆有攻水之效，但水下之后，旋即正气不支，因而有致死的危险。因此，对肝硬化腹水要多补少攻，使其脾肾之气有力运转，则可有一线希望。

第十章 肝虚证治

肝以血为体，以气为用，血属阴，赖气以运，气属阳，以血为基础。肝体阴而用阳，正常功能的发挥，必须藉阴阳气血平衡为条件。

肝虚证是指肝脏气、血、阴、阳不足所引起的病证。有属于血亏而体不充者，也有属于气衰而用不强。所以肝虚证应当包括肝血虚、肝气虚、肝阴虚、肝阳虚四种。过去局限于把肝虚证指为肝血不足，这就会导致概念不全面，任何一脏都具有阴阳气血不足的病证，肝脏也不能例外。

正常的肝气和肝阳是使肝脏升发和调畅的一种功能，故称“肝用”。若这种能力减弱，便会出现懈怠、忧郁、胆怯、头痛麻木、四肢不温等症，这就是肝气虚和肝阳虚的证候。《圣惠方》说：“肝虚则生寒，寒则苦胁下坚胀，寒热，腹满不欲饮食，悒悒情不乐，如人将捕之，视物不明，眼生黑花，口苦，头痛，关节不利，筋脉挛缩，爪甲干枯，喜悲恐，不得太息，诊其脉沉滑者，此皆肝虚之候也。”这里包括了肝血和肝气两者之虚，但以肝虚则生寒（寒即阳不足）为辨证眼目。滋养和充实肝脏的物质，称为“肝体”，若这种物质不足，就是肝体不充，从而可表现出：肝血不足而见眩晕，消瘦，脉细，舌质淡，妇女经少，经淡，经闭；肝阴不足而见头目眩晕，久视昏暗，潮热盗汗，神疲痠痹，舌绛苔少等症。由于体用密切相关，阴阳与气血不可分离，所以在病变过程中也不能绝对划分。

“虚则补之”，是论治肝虚证的原则。临床上应根据虚在何处、虚的程度，而分别采用不同补法，如补肝气、补肝血、补肝阴、补肝阳等。王旭高所以能够分别气、血、阴、阳不足，而分别补之，即是其长。现具体分述如下：

一、肝血不足

症状：面色无华，眩晕，夜寐多梦，耳鸣如蝉，两目干涩，眉棱骨

痛，视物模糊，或有雀盲，爪甲不荣，妇人则经量少或经闭，舌淡，脉细。

证候分析：肝血不足，不能充养头面，故面色少华而眩晕，耳鸣如蝉，舌淡；血不能上濡于目，故两目干涩，眉棱骨作痛，视物模糊或雀盲。妇女则经脉失其濡养，血海空虚，故月经量少或经闭，血不足则不能充盈脉道而脉细。《笔花医镜·肝部》说：“肝之虚，肾水不能涸木而血少。脉左关中弱或空大，其症为胁痛，为目干，为眉棱骨眶痛……”

治法：滋补肝血。

方药：补肝汤（《医宗金鉴》）

当归12克，白芍12克，川芎10克，熟地黄12克，炒枣仁10克，麦冬12克，甘草10克，木瓜12克。

方义：方中以川芎、当归之“动”，以行血中之气，以熟地、白芍之“静”，以养血中之血，以枣仁、木瓜、麦冬、甘草，意在取其酸甘化阴以护肝阴，故本方对肝血不足之证有较好的效果。

四物汤虽不是补肝血的专方，但因肝藏血，故比较多用。临床上可去滋腻的熟地和偏于辛窜的川芎，专取归、芍二味。前人用四物汤加减治疗肝病的方剂甚多，如柴胡清肝饮治疗肝胆火盛，挟有风热之症，即于原方加黄芩、连翘、山梔、牛蒡、防风、天花粉、甘草，即是其例。

肝病过程中，辨证属于肝血不足，未至化火动风之变，皆可用补肝汤治疗。但应注意加减运用：①血虚挟滞，宜去辛香走窜的川芎，以免伤阴动血，佐少量的桃仁、红花以行其滞；②血虚有热，去熟地，加甘寒之生地使其凉血养阴；③血不自生，得阳则生，必要时应佐以甘温益气之品，可酌加黄芪、党参等药；④如血虚而又见血热且瘀之证，须攻补兼施，可酌加鸡血藤、丹参、丹皮、赤芍等药，切忌逐瘀破气之品。

肝病过程中，因肝藏血，心主血，心肝阴血皆见不足，血不濡气，神志失和，出现“脏躁”之证，无故悲伤欲哭，不能自立，头晕耳鸣，惊惕少寐，舌心发干而不欲饮，治宜滋血润燥，甘缓和中，可选用《金匱要略》甘麦大枣汤加酸枣仁、白芍。

二、肝阴不足

症状：头目眩晕，耳鸣筋惕，低热起伏，五心烦热，盗汗，舌绛苔

少，脉细弱而数。

证候分析：肝血虚证进一步发展，使肝阴亏乏，是以头目眩晕而筋惕。阴虚则生热，故五心烦热，或低热起伏。肝肾精血同源，损则俱损，荣则俱荣，肝阴不足则肾水亦乏，故耳鸣、盗汗。舌绛苔少、脉细弱而数，为肝阴不足之征。

治法：滋阴柔肝。

方药：叶天士养肝阴方。（《临证指南医案》）

生地15克，天冬15克，阿胶10克，女贞子15克，旱莲草15克，白芍15克，茯神12克，鸡子黄2个（另化）。

方义：方中以女贞子、旱莲草、生地以补肾阴，使肾水足而涵肝木；芍药佐阿胶补阴之中而又敛阳；天冬养阴柔肝；茯苓甘淡利水宁神，共奏养阴柔肝之效。

【案例】

夏月进酸苦泄热，和胃通降，为阳明厥阴治甚安。入秋凉爽，天人渐有收肃下降之理，缘有年下亏，木少水涵，相火之风旋转而上，熏灼胃脘，冲逆为呕，舌络被熏，则绛赤如火，消渴便阻，犹剩事耳。凡此皆属中厥根萌，当以慎养为宜。

生鸡子黄一枚，阿胶一钱五分，生白芍三钱，生地黄三钱，天冬一钱（去心），川黄连一分（生），上午服。（《临证指南医案》）

【按语】

本案水亏风旋，熏灼胃脘，是以肝阴肾水皆显不足，故以黄连阿胶汤去黄芩加生地、天冬以泻火滋水。本案较前述之证有所发展，因黄连阿胶汤泻心火，苦甘寒合剂，今去黄芩之苦寒，加生地黄、天冬，意在酸甘化阴，重在柔润壮水，以镇刚亢之炎威。若误用刚燥，则易致厥阴无一息之宁而病反剧。黄连阿胶汤用黄芩、黄连泻心火以交通心肾，而本方不用黄芩少用黄连，意重在补肝阴，药味配伍不同，故主治亦不同。

肝藏血，肾藏精，精血皆属阴，同源而异各异用。肝肾精血关系密切，若肾精充足，则肝之阴血亦旺，若肾精亏损，必导致肝阴、肝血不足，所以欲养肝阴，必滋肾精，肾精得充，则肝阴自不伤，前人有“补肾即所以补肝”之说，道理就在于此。临床上可选用六味地黄汤加酸甘补阴之品，即可有补肝阴的作用。

补肝阴并不难，难的是欲速不达，阴血难以骤复是也。若阴亏而气滞，阴亏而风阳上浮，阴亏而血瘀，阴亏而风动、火升、痰生，则不属于纯阴虚证，不在本章讨论之列，肝病伤阴证治中，任何复杂的病证，滋阴仍不失为治本之图。

三、阴损及阳

症状：脉动似数，按之不鼓，便血日久，吸促如喘，心悸、耳鸣，或脉数悠悠，头巅疼痛，自利兼喘，汗出淋漓，昏倦如寐，舌紫绛不渴。

证候分析：便血，下痢日久，以致肝肾之阴欲脱，故脉动似数，按之如鼓，甚则汗出淋漓，昏倦如寐，舌紫绛不渴；阴脱而风阳外越，故见息促、巅痛、心悸、耳鸣。肾阴竭，关闸失司，是以便血失度，甚至厥脱。

治法：固摄平肝。

方药：加味赤石脂禹余粮汤。（叶天士方）

禹余粮15克，赤石脂15克，人参10克，五味子10克，山萸肉 10克，木瓜12克。

方义：本方原载《临证指南医案》，方中以禹余粮、赤石脂之外刚内柔，味酸质厚，能填阳明空漏，人参益气生津，合木瓜以入胃，五味子、萸肉酸收敛阴固液以熄肝风。盖阳明阳土，宜济以柔，误用刚燥，虑其劫液。因此，固胃关就是固少阴，滋化源，即所以救肾阴也。

由上可知，肝病过程中，肝阴不足（肝血不足）在临床并不少见，但与肝火伤阴有关证治有别，宜前后参看。阴脱及阳者，亦应与肝阳（肝气）虚证相鉴别。

四、肝气虚衰

症状：胁肋胀满，少有疼痛，气短不足以息，难以平卧，头重目眩，四肢乏力，纳差，脉两寸细微无力，左关弦细。

证候分析：肝气虚怯，疏泄不及，气机郁滞，是以胁肋胀满，或有疼痛。气虚则温升不足，气血不能上达，故头重目眩，气短不足以息，而难以平卧，两寸细微无力。左关弦细，皆为肝气不足之征。

治则：补肝益气。

方药：理郁生陷汤。

生黄芪30克，知母9克，当归10克，桂枝尖5克，柴胡 5克，生龙骨、牡蛎各10克。

方义：方中重用黄芪大补肝气，昔人皆以黄芪为温脾益气之品，其实补肝作用更胜一筹，张锡纯说：“凡遇肝气虚弱不能条达，用一切补肝药不效，重用黄芪。”佐知母凉润之品，以制黄芪之热，柴胡疏肝理气，当归身养血，桂枝暖肝，生龙牡重镇肝魂，从而本方升而不散，温而不热，为其特点。

本方原无龙骨、牡蛎，而有生乳香、没药。因生乳、没有刺激胃壁而引起呕吐之弊，故用龙骨、牡蛎取代，既能安神，又能固涩精气而保肝。

【案例】

邑王氏女，年二十余，心中寒冷，饮食减少，延医服药，年余不效，且羸瘦。后余诊视，其左脉微弱不起，断为肝虚证.....用黄芪24克，柴胡、川芎各3克，煎汤饮下，须臾左侧即可安卧，又服数剂，诸病皆愈。（《医学衷中参西录》）

【按语】

笔者体会，凡见到脾胃病，只要左关微弱，用理郁升陷汤，皆有效验。本案“左脉微弱不起”，即断为肝虚证，而重用黄芪，不数剂而愈，说明温补肝气在临床上确有实用价值，切勿执“肝无补法”之论。至于如何补法，我们在下面重点讨论。

五、肝阳虚衰

症状：精神悒悒不乐，头痛目眩，胸胁满闷，懒言善太息，神疲气短，肢冷便溏，小腹冷痛，舌淡，脉虚弦。

证候分析：《圣惠方》云：“肝虚则生寒。”因肝脏为一阳生化之气，内寄相火，肾中真阳寄于肝胆之中，若肝阳不足，肝魂不振，故精神悒悒不乐，头痛目眩。肝虚则脾土不运，故肢冷便溏，肝经络于小腹，故见小腹冷痛。肝虚则疏泄不及致气郁，故懒言善太息，神疲短气。阳气不运，故胸胁满闷。舌淡，脉虚弦，则主肝阳不足。

治法：温肝益气。

方药：桂枝加桂汤。

桂枝15克，白芍12克，炙甘草10克，生姜10克，大枣10克。

气虚甚者，加人参、黄芪；阳虚甚者，加肉桂、淡苁蓉、鹿角、巴戟天、木瓜；少腹冷痛加吴茱萸、生姜。

方义：方中以桂枝加桂汤，重用桂枝疏肝木之逆，温肝阳之虚。气虚甚佐参芪温升益气，阳虚甚加温润之品以温肾阳，肾阳充则肝阳亦旺。

【案例】

陈某，男性，38岁。患慢性肝炎三年，三年前因急性肝炎迭进苦寒，肝脾之阳受损，黄疸虽退，但腹痛、胁痛、胀闷之症有增无减。谷丙转氨酶始终不正常，时高达250单位，近日来头晕而痛，动则更甚，伴腰酸神疲，精神悒悒不乐，时心悸气短，四肢不温，懒言，善太息，舌质暗淡、苔薄黄，脉虚弦细弱。辨证为肝阳虚衰，疏泄不及，气滞血瘀，治宜温肝益气，疏肝化瘀。拟方为：桂枝14克，当归12克，白芍12克，黄芪30克，淡吴萸3克，生姜8克，枳壳12克，川厚朴12克，仙灵脾12克，菟丝子15克。服药10剂，诸症明显好转，再守原方出入，佐以健脾之品，调治三月，渐愈。

【按语】

历代医家论肝者，多论其有余，少论其不足，而论肝气肝阳不足者尤少。我们认为：肝内寄相火，寓一阳生化之气，寄居肾中真阳，“凡动皆为火，”“天非此火不能生物，人非此火不能有生”（《相火论》）。若肝阳不足，则机体生化困乏。黄元御认识到肝阳重要，把肝

阳与脾阳相提并重，强调“生气不足，十当八九”，可见肝气、肝阳虚衰确有其病理基础。

近代医家蒲辅周曾提出过：任何一脏皆有气血阴阳，肝脏也不例外，并认为，“肝阳虚则筋无力，恶风，善惊惕，囊冷，阴湿，饥不欲食。”（《蒲辅周医疗经验集》）其实肝阳虚衰，皆有其证候特点，诸如惊恐伤肝，起病急，症状多变等等皆是。

肝气、肝阳虚证是导致疏泄不及的一个重要病理环节，这不仅是由肝气肝阳本身的生理功能所决定的，而且有其客观的病理基础。《素问·方盛衰论》说：“肝气虚则梦见菌香生草，得其时则梦伏树下不敢起。”《灵枢·天年》云：“五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始减，目始不明。”由此说明，《内经》中也早就认识到肝气虚、肝阳虚可表现出不同的病理变化规律。

至于肝阳虚的论治，虽然王旭高在《西溪书屋夜话录》中，列出了补肝气、补肝阳的药队，但所列的药物，多泥于祛风范畴，且没有新的见解，所以我们提出桂枝加桂汤可作为治疗肝阳不足的代表方。

桂枝加桂汤原载《金匮要略·奔豚气病脉证并治》，而《伤寒论》同时亦载其方。奔豚病，有“气冲少腹上冲于心”之证，严重时“发作欲死，复还止”，病机为阳虚阴乘所致，这与肝阳不足的证候特点和病机都极为吻合。桂枝加桂汤，取其调和营卫，降冲平逆，又重用桂枝温疏肝木，对肝阳虚衰之证也确有效验，如前引陈案，就说明了这一点。

诚然肝阳虚衰有轻重之别，气虚为阳虚之渐，阳虚为气虚之甚，两者无绝对界线，但有轻重之分。景岳的暖肝煎，虽名曰暖肝，实是以温通为法，所以临床上，可用桂枝加桂汤温肝阳之虚，气虚甚者加黄芪、党参；阳虚甚者必佐酸甘温养之品，如肉桂、苁蓉、仙灵脾、鹿角、巴戟天、菟丝子、山萸肉、枣仁、木瓜、枸杞等品，并适当配伍川厚朴、砂仁以畅气机，从而可达温肝理气之效。

六、肝虚欲脱

中医学中之谓脱，系指病情突变，垂危于顷刻，阴阳几欲相离的重症。前人论脱有阴脱阳脱之别，责其元阴元阳虚惫而致，唯张锡纯从肝虚立论，颇独出心裁。

症状：喘逆迫急，或呕吐不止，或吐血不止，或汗出浑身如洗，目上窜不露黑睛，或短气不足以息，或努力呼吸有似乎喘，或气息将停，危在顷刻，脉沉迟微弱，或六脉不全，或参伍不调，或失语，或小便失禁，或大便滑泄。

证候分析：脱由虚极所致，虚在何处，唯张锡纯认为：“肝胆虚极，而元气欲脱也”。并谓：“元气之上行，原由肝而敷布，而元气之上脱，亦即由肝疏泄也”。“诚以肝能为肾行气，即能泻元气自下出也。”因此，“元气之上脱由于肝，其下脱者亦由于肝。”（《医学衷中参西录》）

因气逆不降，而见喘逆迫促，或呕吐不禁，或吐血不止，为上脱之候。

汗出浑身如洗，目上窜不露睛，为元气随汗外脱之征，胸中大气下陷，气随陷而随脱，故见短气不足以息，或努力呼吸有似乎喘，或气息将停，危在顷刻，脉沉迟微弱，或六脉不全，或参伍不调诸症。

若阴欲下脱，可见小便失禁，或大便溏泄诸症。

治则：升补肝气以固脱，酸敛收_瀉以护肝。

方药：根据阴脱、阳脱之别，上脱、外脱、阴阳两脱的不同病情，分别采用不同方剂。

1.上脱

参赭镇气汤。（《医学衷中参西录》）

组成：人参12克，赭石18克，苏子6克，生芡实15克，生山药15克，山萸肉18克，生龙骨18克，生牡蛎18克，生杭芍12克。

方义：原书云：“治阴阳两虚，喘逆迫促，有将脱之势，亦治肾虚不摄，冲气上干，致胃气不降作满闷。”方中以人参补之，借赭石、苏子下行之力镇安奠定以挽元气，山药、杭芍补肝肾之阴以纳元气，又以萸肉、芡实、龙骨、牡蛎群队酸涩之品以固涩元气，由补气镇摄兼滋阴敛纳为法组方，共奏降冲逆之气，挽将脱之元阳的效果。

【案例】

一妇人，年三十余，劳心之后兼以伤心，忽喘逆大作，迫促异常。其翁知医，以补敛元气之药治之，胸中窒碍不能容受。更他医以为外感，投以小青龙汤喘益甚。延愚诊视，其脉浮而微数，按之即无，知为阴阳两虚之证。盖阳虚则元气不能自摄，阴虚而肝肾又不能纳气，故作喘也。为制此汤，病人服药后，未及复杯曰：“吾命休矣”。询之曰：“从前呼吸惟在喉间，几欲脱去，今则转落丹田矣”。果一剂病愈强半，又服数剂痊愈。（《医学衷中参西录》）

【按语】

从来救脱，或桂附以挽元阳之脱，或大小定风、三甲复脉以挽元阴之脱，或生脉散以挽气阴两虚，有效有不效者，张氏阴阳并理，补气中寓镇摄，滋阴中寓敛纳，从肝主论，实开了救脱的新法程。本案补敛元气反敛邪气，而“胸窒碍不能容受”，以小青龙汤，虚作实治病反剧，阴阳两虚之证，喘逆迫促之甚可知，服参赭镇气汤之后，从呼吸“惟下喉间”，而“转落丹田”，明显由浅表呼吸而转入有根之吸纳吐故，可见其效果之大，洵非虚语。若因吐血过多者而见喘促咳逆，血脱而气亦脱，可用保元寒降汤（同书）补敛兼用。

2.外脱

来复汤。（《医学衷中参西录》）

组成：山萸肉60克，生龙骨30克，生牡蛎30克，生杭芍18克，野台参12克，炙甘草6克。

方义：张氏认为：“萸肉救脱之功，较参、术、芪更胜。盖萸肉之性，不独补肝也，凡人身阴阳气血将散者，皆能敛之。故救脱之药，当以萸肉为第一。”辅以芍药补肝，佐龙牡敛之，则能固摄元气而止汗，

使气无外脱之虑。

【案例】

一人，年二十余，于孟冬得伤寒证，调治十余日，表里皆解。忽遍身发热，顿饭顷，汗出淋漓，热顿解，须臾又热无汗。若是两昼夜，势近垂危，仓促延愚诊治。及至，见汗出浑身如洗，目上窳不露黑睛，左脉微细模糊，按之即无，此肝胆虚极，而元气欲脱也。盖肝胆虚者，其病象为寒热往来，此证之忽热忽汗，亦即寒热往来之意。急用萸肉二两煎服，热与汗均愈其半，遂为拟此方，服两剂而病若失。

【按语】

由于张氏认为，“凡人元气之脱，皆脱在肝”，所以力主酸敛之品以救欲脱之候。萸肉酸涩微温，能补益肝肾，故推为固脱之首，继则于酸敛之中，善用龙骨、牡蛎以固敛，谓龙牡“但敛正气，而不敛邪气”，两相配伍，萸肉之收，得龙牡之涩，元气即可因而不散。

3.大气下陷欲脱

升陷汤。（《医学衷中参西录》）

组成：生黄芪18克，知母10克，柴胡5克，升麻3克，桔梗5克。

方义：方中以黄芪补气、升气，伍柴胡引入肝以升补肝气，知母凉润制大剂黄芪之热，升麻引阳举陷，桔梗舟楫之品，载药达胸，使气补而不滞，升而不散，达升气固脱之效。

【案例】

一人，年二十四。胸中满闷，昼夜咳嗽，其咳嗽时，胁下疼痛甚。诊其脉象和平，重按微弦无力。因其胁痛，又兼胸满，疑其气分不舒，少投以理气之药。为其脉稍弱，又以黄芪佐之，而咳嗽与胸闷益甚，又兼言语声颤动。乃细问病因，知其素勤稼穡，因感冒懒食，犹饥腹力作，以致如此。据此病因，且又服理气之药不受，其为大气下陷无疑。遂投以升陷汤，四剂，其病脱然。（同书）

【按语】

看来升陷汤证的鉴别，不谓不难，要不然张氏自制其方，而竟“少有差错，犹幸迷途未远”，其实，得一之情，细询病史也，“感冒懒食”，“素勤稼穡”，其劳伤气可知，“服理气之药不受”，自要考虑与气虚下陷有关。可见，“伏其所主，必先所因”。

4. 阴阳两脱

既济汤。（《医学衷中参西录》）

组成：大熟地30克，萸肉30克，生山药18克，生龙骨18克，生牡蛎18克，茯苓9克，生杭芍9克，乌附子3克。

方义：方中以山药、熟地峻补真阴，萸肉、龙牡补肝收敛，少用附子引上越之阳下归其宅，以期阴阳固结，水火互济，而救上脱下脱之厄，实发展了仲景肾气丸法。

【案例】

一人，年二十余，禀资素羸弱，又取耽烟色，于秋初患疟，两旬始愈。一日大便滑泄数次，头面汗出如洗，精神颓愤，昏昏似睡，其脉上盛下虚，两寸摇摇，两尺欲无，数至七至。延医二人皆无疏方。愚后至为拟此汤，一剂而醒，又服两剂遂复初。（同书）

【按语】

大病之后阴阳不相维系，阳欲上脱，或喘逆，或自汗，精神颓愤，昏昏似睡；阴欲下脱，或失精，或小便不禁，或大便滑泄，此证危在旦夕，而张氏从肝阴阳两虚立论，以既济汤，其效甚好。

张氏从肝虚立论以救脱，是有阴阳之别的。阴虚则风动，风动疏泄太过，致泄元气，所以他强调：“故人虚极者，其肝风必动，肝风动，即元气欲脱之兆。”气虚则大气下陷，大气下陷而脱，必补肝之气，升肝之气始效。

由上所述，张氏救脱从肝虚立论，有理论，有实践，既给救脱法开了新的门径，也为我们论证肝有阴、阳、气、血诸虚证，提供了有力的论据。

总结

肝为五脏之一，由于肝的性能不但与身形内外为一个有机整体，与

自然界也有密切关系，因而，它并不是一个孤立的形态单位。就肝的性能特点而言，主要是体阴而用阳，其“体”之所以为阴，是因为它具有藏血、藏魂的作用；其“用”之所以为阳，是因为它具有升发、疏泄、动摇的气分作用，理解这一点十分重要。

中医的肝病是基于藏象学说的基本精神，以肝脏为中心，以经络为径路，因而概括肝系统，包括所属内外表里脏腑经络组织器官的种种病理变化而言，因此，它也包括现代医家所指的各型肝炎、肝硬化等疾病在内。

中医一贯认为：肝病的发病最急，传变最快，病证最广，因而有“肝病十居六七”，“肝病如邪”，“肝病贼五脏”之说。因此，把握肝病的证治规律，不仅对临床医务工作者很重要，即使是对患有肝病的患者，也不无裨益。

本书总论概括了肝的生理、病理、诊断、治疗的特点，也即是概括了肝病不同于其他疾病的特有规律。各论部分，则首先从肝气结郁开始，阐明了肝郁在诸郁发病中的地位，进而论及肝气抑郁、肝郁挟痰、肝郁挟热、肝郁挟寒、肝郁挟食、肝郁挟湿等不同证治规律，既把握肝郁的共同规律，也掌握挟痰、挟热、挟寒、挟食、挟湿的不同个性，因而有不同的治疗方法。若湿热诸毒伤肝，可表现出有黄疸或无黄疸的不同，因邪的不同性质，有不同的致病特点，形成不同的证候，如湿热在肝、湿毒热凝结、湿热发黄、瘀血成疸、疫毒成疸、寒湿成疸，这些证候之间，既有其共同规律，也有不同特点；肝气冲逆虽然所反映的大都是肝气有余的病变，但根据肝病所伤部位脏腑经络不同，又可分为气逆本脏、气火内郁、肝气冲心、肝气犯肺、肝气克脾、肝气乘胃、肝气伤肾、肝气迫及冲任等证候，肝气郁而化火，火性燔灼则又可出现：肝火上炎清窍、肝火内扰胸脘、肝火扰魂、肝火冲斥三焦、肝火犯肺、肝火扰心、肝火伤脾、肝火灼肾、肝火动血、肝火下迫大肠诸证，证不同而治亦有异。若肝火进一步伤阴，突出表现以阴虚为主者，则又要分别灼伤肝阴、中伤胃阴，下伤肾阴，所伤不同，论治皆有不同特点；若肝气、肝火进一步化风，形成肝风证，因为风有虚风、实风，故又需分为肝火动风、肝阳上亢、阴虚风动、肝风挟痰、湿热在经、肝风内动、肝风内动窜犯心包、脾虚风动诸证。因为肝关系气血，气血反映肝病“体”、“用”失调运一基本矛盾，气血瘀滞是常见证候，其中可分为肝血瘀滞、肝血瘀而有腹水、肝脾之积、肝着、肝络不和、肝寒血凝经脉等证，肝属厥阴，与少阳相表里，当少阳一阳来复，又易出现寒热错杂之证，其中有寒热错杂、肝热脾寒、上热下寒等证；若肝受寒邪，可见肝寒浊阴上逆、寒滞肝脉、肝病腹胀而脾肾虚寒；最后，对肝病虚证进

行了探讨，不仅论治了肝血、肝气、肝阴、肝阳虚衰等证治规律，而且对阴损及阳，肝虚欲脱之证也作了阐述。由于肝的生理在人体生命运动的重要性，所以认识肝病也必须从整体出发。肝病既是一个十分复杂的疾病，而且各种病证之间，又有着密切的内在系联，只有把握各类证候的主要脉证特点和它们之间相互联系、相互转化的规律，则辨证论治才能有的放矢，并取得满意的治疗效果。

下篇 附篇

一、《西溪书屋夜话录》评讲

《西溪书屋夜话录》，是清代名医王旭高所著。王旭高生于清嘉庆、同治年间（约1798—1862年），字泰林，江苏无锡人。幼从其舅父高锦庭习疡科，后专内科。著有《医方证治汇编》、《退思集类方歌括》、《增订医方歌括》、《薛氏湿热篇歌括》、《医方歌括》、《医学刍言》、《西溪书屋夜话录》等书。其临床医案，由虞山、方耕霞搜集编次，整理成《王旭高医案》，分为四卷二十六门，复加按语，每门后又附有小结，颇能窥见王氏的治疗经验。

王氏勤求古训，博采众议，上承《内经》、《难经》及仲景之说，旁参明清诸家之言，取诸长而并蓄，融化于一炉。其《医学刍言》一书，即是饱览诸家著作，参以己得而成。它扼要地论述了临床常见病（证）的辨治原则，其中“六淫治法”一篇就是一例。如其论治“火”则分“实火虚火”、“三焦之火”、“五脏六腑火”，并谓：“实火宜苦寒，黄芩、黄连、山梔、黄柏，甚则大黄；虚火宜甘寒，鲜地黄、沙参、元参、麦冬、石斛、梨、蔗汁……上焦火，黄芩、桑皮、甘草；下焦火，黄柏、知母。”这些清火的见解，反映了王氏医学的特点之一。

《西溪书屋夜话录》，可以说是王氏的医学代表作，该书把肝病分为肝气、肝风、肝火三大类，然后分别进行论述，提出疏肝、柔肝、缓肝、泻肝、抑肝、熄风、养肝、温肝、化肝以及补母泻子、培土泄木、泄肝和胃、清金制木等法，并认为“肝气、肝风、肝火三者同出而异名，其中侮脾乘胃，冲心犯肺……种种不同，故肝病最杂而治法最广。”从而，使王氏成为后世治疗肝病的楷模。可惜的是，该书从其体例来推敲，似有残缺不全之处，故周镇谨在书后跋曰：“此篇说理精当，想其原书卷帙必多，不仅此一篇也。”其说自有所见，而非泛泛之论。

王氏《西溪书屋夜话录》所以能有较大的成就，与他所处的时代的

影响有关。他生于清代温病学说成熟的时代，对其甘寒养阴，平肝滋胃，忌刚药喜柔润的方法不无影响，而又对魏柳洲、叶天士的温病学说亦有所借鉴，所以他的《西溪书屋夜话录》在治肝的观点上，另辟蹊径，成为历代治疗肝病的一部专著。为了提供读者参考，现选录其文如下：

（一）“肝气、肝风、肝火三者同出异名。其中侮脾乘胃，冲心犯肺，挟寒挟痰，本虚标实，种种不同，故肝病最杂而治法最广。姑录大略于后。”

1.提要 本段为全篇之纲，首提肝病有肝气、肝风、肝火之分，并示肝病有干犯他脏以及本虚标实种种不同的证治，提纲挈领，重点突出。

2.词解

（1）肝气：属于生理、病理的名词，也可作为证候名。属于生理的指肝脏之气；属于病理的，指肝之气机不和，出现疏泄不利的种种病证。

（2）肝风：病理名词，亦作证候名。《内经》亦称肝风。王氏这里所指包括肝阳化风和风阳内动。方耕霞说：“夫肝之所以生风，由肾水不足灌溉，致木燥火生，火生风起。”

（3）肝火：病理名词，亦作证候名。多指肝气郁久化热，或情志过极所出现肝火等证而言。

（4）侮脾乘胃：肝属木，脾胃为土。“肝病必犯土，是侮其所胜也。”也就是说，肝气横逆，亦可以致脾胃病变，其中，侮脾可致脾失运化，表现为恶心干呕，脘痞不食，吐酸水涎沫。

（5）冲心犯肺：心肺两脏同居上焦，肝气横逆肆无忌惮，则能乘心侮肺，而见心、肺的证候，故曰肝气上犯。

3.评注

（1）关于肝气、肝风、肝火“同出而异名”的问题，是指肝气、肝风、肝火之名，都是从肝的病理角度提出的。由于“气、火、风”都为肝用太过所致，始于气郁，化而为火，盛则为风，故曰：“郁则为肝气，发则为肝火，盛则为肝风。”“气、火、风”都是从厥阴肝经而来，始于气机不和，故曰“同出”，当然同出不等于没有差异，其中区别又在于：阻滞于内都是气，冲抗于上皆属于火，升及头巅或旁走四肢则为风，故曰：“异名”。王氏这一论点，有机地阐明了气、火、风三者的内在联系，对临床治疗肝病有很大的指导意义。

(2) 关于“本虚标实”的问题。“本虚标实”，是肝病发生发展过程中的共性规律。本虚是指肝阴阳气血不足，标实是指在本虚基础上继发的寒、瘀、痰、风、火等不同证型。如阳亢之体，源于水亏，肝脏体阴不足而阳用有余，有余则肝阳上亢，这就说明了阳亢是一个标证，至于阴亏才是本证。论治就应本着“急则治标，缓则治本”的原则，权衡标本缓急。如阳亢急剧，予以平肝潜阳，阳亢平息后，用滋阴之法即是治本。这里仅举例而言，说明解决本虚标实的矛盾，是肝病诊治过程中一个需要重视的问题。

(二) “一法曰：疏肝理气。如肝气自郁于本经，两胁气胀或痛者，宜疏肝，香附、郁金、苏梗、青皮、橘叶之属。兼寒加吴茱萸，兼热加丹皮、山梔，兼痰加半夏、茯苓。”

“一法曰：疏肝通络。如疏肝不应，营气痹窒，络脉瘀阻，宜兼通血络。如旋覆花、新绛、归须、桃仁、泽兰叶等。”

“一法曰：柔肝。如肝气胀甚，疏之更甚者，当柔肝，当归、杞子、柏子仁、牛膝。兼热加天冬、生地，兼寒加苁蓉、肉桂。”

“一法曰：缓肝。如肝气甚而中气虚者，当缓肝，炙草、白芍、大枣、橘饼、淮小麦。”

“一法曰：培土泄木。肝气乘脾，脘腹胀痛，六君子汤加吴茱萸、白芍药、木香。即培土泄木之法也。”

“一法曰：泄肝和胃。肝气乘胃（即肝木乘土），脘痛呕酸，二陈加左金丸，或白蔻、金铃子。即泄肝和胃之法也。”

“一法曰：泄肝。如肝气上冲于心，热厥心痛，宜泄肝，金铃、玄胡、吴茱萸、川连。兼寒，去川连，加椒、桂；寒热俱有者，仍入川连，再加白芍。盖苦、辛酸三者，为泄肝之王法也。”

“一法曰：抑肝。肝气上冲于肺，猝得胁痛，暴上气而喘，宜抑肝。如吴茱萸汁炒桑皮、苏梗、杏仁、橘红之属。

1.提要 本段提出肝气证治的治疗八法。

2.词解

(1) 柔肝：叶天士提出：“肝为刚脏，非柔润不能调和。”凡用酸收、咸软或甘缓等药物组成方剂，以戢敛肝阳，或培补肝肾之阴，皆属柔肝之剂。

(2) 泄肝：泄与泻义通，泄肝即泻肝，但后世所指泻肝，多寓意于清泻肝火，又有别于王氏所讲泄肝之意。这里“泄肝”，系指苦降、辛

开、酸敛合法，实是叶天士所创制肝安胃法，以其酸收以敛肝，苦降辛开以平调胃之寒热，因此说“泄肝”寓有和胃之意。

（3）抑肝：抑肝有广、狭二义之分。广义包括平肝、镇肝，以镇降上亢之肝气风阳。狭义是指抑肝胆升浮之火。王氏所指即为后者，如吴萸汁炒桑皮、苏梗皆属辛降；杏仁苦降，橘红平降，即抑肝之制方。

3.评注 肝气一证，有因郁怒伤肝，有因土不荣木，有因心火气盛，有因金不制木，有因饮食不节，有因寒暑失常。病因不同，病候各异。或自郁本经，或侮脾乘胃，或冲心犯肺，或挟痰挟食，或兼寒兼热，或虚实各异。病候有异，治法各不相同。王氏治疗肝气八法，层次井然，现具体评释如下：

（1）疏肝理气：此王氏开手之法，宜于肝气初起，自郁本经。由于病始于郁，郁则气滞，故首重理气。理气首宜辛开，应不损胃，不耗气，不伤阴，故方取香附、郁金、青皮、苏梗、橘叶等品，虽理气而不伤血。

（2）疏肝通络：经主气，络主血。气郁本经不愈，由经入络，营热则痹，络瘀则痛。若疏肝不应，胁痛不除，且刺痛而固定不移，为“络脉瘀阻”，治宜疏肝通络。此法实源于仲景所制之旋覆花汤，但对瘀阻较重之证，则有病重药轻之嫌，而王清任的活血通络之法，又补充了王氏不足。

（3）柔肝：药味有气味阴阳之别，有动静刚柔之分。叶天士对柔肝药的见解，他认为某些温补药（包括血肉有情之品），性虽温而其质柔润，无刚燥之弊，是柔剂中的温药。温补而不呆滞，故曰温柔。而某些滋阴药（包括养血之品），性凉而质柔，是柔剂中的凉药，故曰阴柔。王氏在这里所列柔肝药，即属温柔，而魏玉璜之“一贯煎”乃为凉柔之方。

（4）缓肝：“肝苦急，急食甘以缓之”。这句话指的是中气不足，土不培木，则肝失养而急，故宜用甘药补脾缓肝。所以王氏说：“肝气甚而中气虚者，当缓肝”。“缓肝”之意不是单纯用甘味，而是在甘缓之中，略佐酸收，取酸甘化阴之义，从而使肝体得柔，而肝急之症得以缓解。

（5）泄肝和胃：肝为刚脏，胃为盛阳，肝木乘土，可表现于肝气横逆犯胃之证，治当泄肝和胃。泄肝重在泻火，左金丸可清肝泻火；和胃重在降逆化痰，而二陈汤亦切合于病情。二方合用，肝胃同治，故王氏用左金丸和二陈汤，必要时加川楝子平肝，白蔻和胃，以加强其泄肝和胃之力。但值得提出的是，临床因肝气乘胃，肝胃不和者，见症颇

多，有阴阳虚实寒热之异，因此，不可以一法以概全貌，《临证指南医案》木乘土门，宜参看之。

（6）泄肝：肝气横逆上冲于心，以致热厥心痛，宜急泄肝气以降冲逆，否则节外生枝，甚或危及生命。何谓泄肝？王氏认为“苦、辛开、酸敛合法”，如乌梅丸为厥阴主方，故亦曰苦辛酸合为泄肝主法。其实，苦辛相合，能降能开，心胃相通，和胃即可治心，佐以酸寒入肝以酸泻之，且肝气逆则胃首当其冲，仲景谓制木先安土，即属此意。由此可见，王氏泄肝是指泄肝安胃法而言，此法治肝气冲心，应分清在气和在血，需要辨证而施治。

（7）抑肝：抑肝是指抑肝下气，以安肺金。王氏这里所指抑肝，比较局限于苦辛降气，不足以概括肝气上冲于肺的证治，即便是见到“猝得胁痛，暴上气而喘”，所列药队，也有病重药轻之嫌。

综合上述，王氏肝气证治八法，确是审证求因的治本之法，他首论肝郁，继而由经及络，由气及血，后又述及侮脾乘胃，冲心犯肺诸变证治。其所主八法，疏肝无偏寒偏热之异，通络而不峻猛，柔肝重在温柔，缓肝意在甘缓以建中，补脾气以泄木，重苦辛合法以和胃，用药在甘辛酸苦平之间审度，无咸凉湿燥阴凝之弊，可见其调治肝气心灵手巧之一斑。

（三）“肝气一证，虽多上冒巅顶，亦能旁走四肢。上冒者，阳亢居多，旁走者，血虚为多。然内风多从火出，气有余便是火。余故曰肝气、肝风、肝火，三者同出而异名，但为病不同，治法亦异耳。”

“一法曰：熄风和阳。如肝风初起，头目昏弦，用熄风和阳法，羚羊、丹皮、甘菊、钩藤、决明、白蒺藜，即凉肝是也。”

“一法曰：熄风潜阳。如熄风和阳不效，当以熄风潜阳，如牡蛎、生地、女贞子、玄参、白芍、甘菊、玉竹，即培土宁风法，亦即缓肝也。”

“一法曰：养肝。肝风走于四肢，经络牵掣或麻者，宜养血熄风，生地、归身、杞子、牛膝、天麻、制首乌、三角胡麻，即养肝也。”

“一法曰：暖土以御寒风。如《金匱》近效白术附子汤，治风虚头重眩苦极，不知食味。是暖土以御寒风之法。此非治肝，实补中也。”

1.提要 本段提出肝风证治及论治四法。

2.词解

（1）内风多从火出：内风亦即肝风，与外邪引起的外热、外风有

别。叶天士说：“内风乃身中阳气变动。”气有余便是火，肝气有余易化火动风，故曰内风多从火出。

(2) 滋阳明，泄厥阴：阳明系指足阳明胃，厥阴系指足厥阴肝。肝为刚脏，胃为盛阳，厥阴之气上干，阳明之气失降，故滋阳明，泄厥阴，意即滋胃泄肝。滋胃包括滋胃阴、养胃气，泄肝包括清肝、平肝等法。《临证指南医案》中滋阳明，泄厥阴之法，在具体应用上仍然很广，应细心研究，方有收益。

3.评注 肝风一证，多由肝火发展而来，但火有虚火、实火之分，风有虚风、实风之别。虚多阴血不足，实多阳亢有余。是以上冒者阳亢为多，旁走者血虚为甚。王氏肝风证治，即宗此说提出，具体分析可有：

(1) 熄风和阳和熄风潜阳：古人把肝风与风阳常常混称，实则有虚实之异。一为阳亢风动，意即肝阳过亢引动肝风，升及头巅，上冒头目，故又称风阳；一为厥阴化风，意即血虚（或阴虚）引动肝风，俗称“肝风证”，其含义较狭。前者多实，有冲激之象；后者多虚，有阴血不足之征。二者标本虚实不同，有在气在血分之异，虽然两者皆以熄风为目标，但前者宜“和阳”，和阳即凉肝之意，宜于肝风初起，肝阳亢盛，肝阴未伤之证，药如羚羊、丹皮、甘菊、钩藤、决明子、白蒺藜等，平肝木之炎盛，解标证燃眉之急；后者则宜潜阳，具有滋肝之意，宜于风阳过亢，肝阴已伤，并进一步劫伤阴血，向虚证转化，如凉肝不应，即宜考虑潜阳，药用牡蛎、生地、女贞子、玄参、白芍、阿胶、菊花等，滋肝以熄风，潜阳以固其本。由此可见，王氏所指熄风和阳和熄风潜阳之法的应用，是肝风病发生发展过程中两个不同病理阶段的基本治疗原则，前者重在治标，后者重在治本，临床应用时，应注意标本缓急。

(2) 培土宁风与暖土御风：“脾为阴土，得阳始运，胃为阳土，得阴自安。”肝风震起，侮脾乘胃，势所必然。其常见病证有二：一是胃阴不足，中虚纳少，胃阴虚而肝风更为肆虐；一是脾胃阳气虚弱，外则遭风寒之邪侵袭，内则易为肝肾浊阴上泛，症见不知食味，风虚头重苦极，风虚即指中气虚弱，头重眩晕而言，且脾气愈虚而寒风愈加肆虐。两者在治疗上绝不相同，前者宜培土宁风，意在滋阳明，泄厥阴；后者宜暖土以御寒风，大建中、附子理中、近效白术附子汤等方皆可使用。应当指出的是，凡脾胃虚弱而致肝风上眩，皆有挟痰、挟湿、挟寒、挟热之别，治疗宜辨证而施，才能有效地应用于临床。

(3) 养肝：营血不足，肝木失养，肝风旁走四肢，经络牵掣，甚则麻木，可用王氏养肝法，意即养肝血以熄风。使用本法时，应注意与

湿热内蕴，流窜经络，引动肝风者相鉴别，后者因脾主四肢，脾虚而湿热盛，应注意健脾。

综合上述，王氏肝风证治，立法有五，宜各随其寒热虚实而调治，但征之临床，仍不足以概括肝风证治中的复杂变化，故宜适当参考书目，扩大视野，增加新的治法。

（四）“肝火燔灼，游行于三焦，一身上下内外皆能为病，难以枚举。如目赤颧红，痉厥狂躁，淋秘疮疡，善饥烦渴，呕吐不寐，上下血溢是也。”

“一法曰：清肝。如羚羊、丹皮、黑梔、黄芩、竹叶、连翘、夏枯草。”

“一法曰：泻肝。如龙胆泻肝汤、泻青丸、当归龙荟丸之类。”

“一法曰：清金制木。肝火上炎，清之不己，当制肝，乃清金以制木火之亢逆也。如沙参、麦冬、石斛、枇杷叶、天冬、玉竹、石决明。”

“一法曰：泻子。如肝火实者，兼泻心。如甘草、黄连，乃‘实则泻其子也’。”

“一法曰：补母。如水亏而肝火盛，清之不应，当益肾水，乃‘虚则补母’之法也。如六味丸、大补阴丸之类，亦乙癸同源之义也。”

“一法曰：化肝。景岳治郁怒伤肝，气逆动火，烦热胁痛，胀满动血等证，用青皮、陈皮、丹皮、山梔、芍药、泽泻、贝母，方名化肝煎，是清化肝经之郁火也。”

“一法曰：温肝。如肝有寒，呕酸上气，宜温肝，肉桂、吴茱萸、蜀椒。如兼中虚胃寒，加人参、干姜，即大建中法也。”

1.提要 本文提出肝火证治七法。

2.词解

（1）燔灼：用火烤叫燔灼，在这里是指肝火对津液精血的消灼而言。因火性上炎，如烈火焰烧，充斥一身上下内外，及于三焦腠理肌肤而有害。

（2）乙癸同源：肝为乙木，肾为癸水。肾藏精，肝藏血，同源而异名，皆生成于津液。

3.评解 肝疏泄气血，其为用也，于机体无处不达。肝寓相火，相火宣布在三焦，所以气郁化火，肝火燔灼，即可游行于三焦腠理，又可充

斥于一身内外上下。冲逆于上则目赤颧红；扰乱肝魂则狂躁；灼伤肝阴则痉厥；扰及心神则不寐；侵犯心营，血热沸溢则病疮疡，上下溢血；火盛伤阴则烦渴；充斥胃脘则善饥；胃逆则呕吐；下伤肾阴及膀胱则淋闭，是以见症多端。治疗之法，据王氏的经验是：

（1）清肝、泻肝、化肝：此三法乃王氏治疗肝火的常规之法。其中区别在于：肝火燔灼于上于外，治宜清中带透，即为清肝；肝火充斥于上下表里内外，以在下在内为主，需苦寒直折其炎盛，故曰泻肝；若郁怒伤肝，气反动火，治宜理气凉肝，即为理气之中，佐以苦寒酸寒以泄折肝经郁火，故曰化肝。三法均遵“热者寒之”的原则，清泄之中而分别佐以不同之法，可见王氏用方，确有法度。后世治肝火之法，多遵此配伍应变于临床。

（2）清金、泻火、补母：肝火燔灼之症，在运用上述清肝、泻肝、化肝诸法以后，一般肝火应得到化解，但亦有“清之不应”或“清之不己”者。治疗上宜知常达变，采用从他脏论治。①清金制木：肝火上炎，运用清肝诸法后，其火仍不能清，可考虑清金制木之法。因肺属金，若金不制木，则木火之气必亢，为此，清金之中即有制木之义。清金之法，宜用清润之品，如王氏所用沙参、麦冬、石斛、天冬、玉竹、枇杷叶等，稍佐石决明以为潜阳于下之计。本方临床应用时，犹可加入菊花、丹皮、山栀子等药，清中带透，恒疗效有所提高。②泻子：肝火亢极，泻本脏不效，应考虑实则泻其子之法。心属火而木生火，故心为肝之子，所以肝火旺则心火必亢，故泻心火即能泻肝火之亢。临床上凡肝火实证皆可佐以泻心火之法。王氏举甘草、黄连为泻心火之方，临床常选用黄连导赤散，重则可用大黄酒泻心汤。亦可将此方佐入清肝之中，如龙胆泻肝汤中的木通、车前子、泽泻利小肠湿热，也具有泻子之义。有肝火炽盛，虽导赤泻心不嫌其峻，甚至兼泻胆火。③补母：若水亏导致肝火盛，清金仍不能平木，宜考虑虚则补其母之法。肾为水，为肝木之母，肾水亏则肝阴不足，阴不潜阳，阴虚火旺，宜滋阴补水以涵肝木。王氏所举六味地黄汤、大补阴丸等方，皆为正治之法。夫水亏则源涸，木拔则苗萎，另一方面，肾又寓火，肾火衰则肝阳亦虚，可致肝阳虚衰，亦可采用补母之法，用温补肾阳之品，达温壮肝阳之用，则肝之虚火自退。

（3）温肝：肝家虚寒，外现虚火，形似火热之症，治疗上非苦寒可以直折，非甘寒、咸寒可以戢敛，唯宜温肝之法。临床上可选用仙灵脾、仙茅、肉苁蓉、巴戟天等温润之品。王旭高以前，少有人论及温肝法，而王氏能予提出，可算是别有卓见，但所选之药如肉桂、吴茱萸、蜀椒为其对药，不免辛燥有余，不足为用；若中虚胃寒时，始可用大建中

汤，因仅从温建中气，使脾阳得运，肝火自熄，毕竟比较局限，笔者认为：宜于温润之中，佐以辛甘养阳，必要时伍以酸收咸软之品以养阴，不单纯温阳，而于阴中求阳，这样方为稳妥。

总之，肝火证有虚有实，实则泻之，热则凉之。由本脏自病者，于清散、清下、清化之中权变，由他脏波及者，宜分别佐入清金、泻子、补母诸法。若肝寒，或虚火时炎，温建中气之外宜重在温肝之阳。

（五）“一法曰：补肝。如制首乌、菟丝子、枸杞子、杏仁、萸肉、芝麻、沙苑蒺藜。”

“一法曰：镇肝。如石决明、牡蛎、龙骨、龙齿、金箔、代赭石、磁石。”

“一法曰：敛肝。如乌梅、白芍、木瓜。”

此三法，无论肝气、肝风、肝火，相其机制，皆可酌情选用。

1.提要 本文提出肝病证治中的应变三法。

2.词解

（1）补肝：虚则补之，凡其有补益肝脏气血阴阳的治法，均可称之为补肝法。王氏这里所指的补肝法，是针对肝血不足而立。与临床习惯所指养肝、滋肝，具有同一意义。

（2）镇肝：含有镇静之义。镇肝主要目的是潜阳熄风，多用于肝阳、肝风而证偏实者。

（3）敛肝：运用酸味药物以养肝阴，使阴充则阳自敛，风自熄，故曰敛肝。多用于肝阳上亢重症，药味多滋腻厚味。

3.评解 王氏提出补肝、镇肝、敛肝三法，可在肝气、肝风、肝火证治中“相其机宜”，灵活应用。因肝病气、风、火诸证的共同病理基础常常是在血不制气，阴不潜阳，继发于阴血不足的基础上，所以血虚甚者宜补肝，王氏这里所指补肝较局限于补肝血，且所举药味，枸杞偏温，用之当慎。阴虚甚而不潜阳，则宜敛肝，实则补肝阴以敛阳，乌梅、木瓜、白芍皆为常用之品。至于镇肝法，实是熄风潜阳重剂，系肝风证治中，较熄风潜阳更重一些，故立法重在潜镇，于此可见，王氏用药颇能丝丝入扣。

（六）“一法曰：平肝。金铃子、蒺藜、钩藤、橘叶。”

“一法曰：散肝。木郁则达之，逍遥散是也，肝欲散，急食辛以散之，即散肝是也。”

“一法曰：搜肝。此外有搜风一法。凡人必先有内风而后外风，亦有外风引动内风者，故肝风门中。每多夹杂。则搜风之药，亦当引用也。如天麻、羌活、独活、薄荷、蔓荆子、防风、荆芥、僵蚕、蝉蜕、白附子。”

1.提要 本文提出肝脏本身病变的特殊性，而表现不完全同于肝气、肝风、肝火的三种治法。

2.评解

(1) 平肝：“惊则平之”。平，谓平顺，平降上冲之气，是针对肝实证而言，既有别于重镇的镇肝法，也有别于熄风和阳的凉肝法。其区别还在于：镇肝法所主治症最重，平肝次之，凉肝又次之。王氏只取川楝子、橘叶以平肝气；钩藤、蒺藜以解欲动之肝风，取药简捷平稳，但仅属平肝轻剂，临床要视症情轻重，予以加减化裁。

(2) 散肝：“结者散之”，凡肝脏气血郁结，宜散肝法。因导致肝气郁结的病因很多，故散肝法的内容亦较广泛，诸如散肝风热，散肝风湿，散肝风气，散肝风寒，散肝热，散肝毒等等不同。这里王氏所指散肝法，主要是指疏散肝脏气血，“疏其气血，令其条达，而致和平”。其立法：一遵《内经》“肝欲散，急食辛以散之”的原则；二据“木郁达之”，亦即令其条达，组织成方。至于逍遥散，系肝郁血虚的代表方，不能作为辛散的代表方，因而散肝法应有新的内容。

(3) 搜肝：意即搜风法。肝风为内风，系“身中阳气变动”所致，但也有外风引动内风者，或先有内风而后外风侵袭，外风与内风合邪，窜犯空窍经络。内外风“每多夹杂”，故搜风之药亦当引用，有时外风去则内风自平，故用天麻、羌活、防风、荆芥、薄荷、蔓荆子、僵蚕、蝉蜕、白附子等品。凡症见四肢麻木，口眼歪斜，肌肤不仁，半身不遂等症，皆可应用。但毕竟本法偏于搜剔外风，若阳亢风动较剧，当宜慎用，或配伍平肝熄风之剂，谨防其劫燥伤风之弊。更为重要的是，常宜结合养血之品，所谓“治风先治血，血行风自灭”，所以单纯搜风之品，只可暂用而不可久用。

(七) “一法曰：补肝阴。地黄、白芍、乌梅。”

“一法曰：补肝阳。肉桂、川椒、苁蓉。”

“一法曰：补肝血。当归、川断、牛膝、川芎。”

“一法曰：补肝气。天麻、白术、菊花、生姜、细辛、杜仲、羊肝。”

1.提要 本文提出补肝四法。

2.评解 五脏六腑皆有气、血、阴、阳，肝脏亦不例外。在肝病发生发展过程中，肝脏可表现出气、血、阴、阳之不足，一方面不足会导致另一方面有余，本着“虚则补之”的原则，补其不足即是泻其有余，故有补肝阴、补肝阳、补肝气、补肝血的不同。王氏列举药队不足之处，其补肝阴宜与前述滋肝、养肝、柔肝诸法对比活看，其补肝阳不免过于辛燥，亦宜合温肝法权衡应用，应以温润为主，其补肝血，宜与养肝法配合应用，非川芎、川断所宜，补肝气中仅杜仲、羊肝有补肝之用，他如天麻、细辛、白术、菊花皆无补意，实祛风之品。不过王氏能分别提出补肝之气、血、阴、阳，这在当时来说，确是一个进步，对执“肝无补法”之论者，恰是一个较好的回敬。

总之，王旭高《西溪书屋夜话录》肝病证治，虽其理论部分大部残缺，但从其实用价值来讲，仍不失其为肝病证治专篇。其结构比较周密，立法比较严谨。先以肝病本身寒热虚实的不同形症为纲，以肝气、肝风、肝火为目，步步深入，紧密结合临床实际进行研究。既注意到肝病本身的变化规律，也揭示了相关脏腑的影响，于标本、先后、缓急或隔一、隔二等法中求治法。王旭高其所以具有如此真知灼见，与当时温病学说的成熟，发展有着密切关系。我们从柳选《环溪草堂医案》及《王旭高医案》的对比之中就不难看出，他在很大程度上师承叶氏，立法不拘成方，用药以清灵见长。事实上王氏的《退思集类方歌括》是以徐灵胎《伤寒类方》为蓝本，其《医方歌括》只是概括《兰台轨范》通治诸方。而最能反映王氏学术思想的，当推《西溪书屋夜话录》。但细读起来，该篇仍有不足之处。①叙证过简，语多重复罗列，如“培土宁风.....”一节，总共43字，重复者达23字之多，其云补肝、柔肝，皆只是名异实同；②有些治法举例用药欠当，如抑肝法，列举桑皮、苏梗、杏仁、橘红等品，远不能概括抑肝之治。而且，在所有治肝药队中，竟不列柴胡，这不能不是一个很大的不足；③个别地方论理欠清，如“肝火证治”中温肝法，非指实火，当是下焦阳虚，浊阴激动龙雷之火上浮所致，但作者交代不清，不免使读者有支离破碎之感。这也可能与该书残缺不全，理论部分存者很少有关。

二、胆腑理论及临床

胆腑理论是以研究胆的生理功能、病理变化为中心的理论，它是在祖国医学藏象学说的指导下，对胆腑所作的整体认识。

胆为奇恒之腑，既不同于“藏精气而不泻”的五脏，也不同于“传化物而不藏”的六腑。其生理活动与病理变化，有其独特的表现和一定的规律可循。

肝与胆互为表里，经脉互相络属，又同应春生之气，故胆与肝的生理、病理有相同之处，但是，肝与胆毕竟是一脏一腑，一表二里，在生理和病理上又有不同之处。为了使读者在掌握肝病证治规律的同时，对胆腑的生理、病理及其证治规律，有一个概括性的了解，不至于发生临床茫然无措，故在此进行分析，以供临床参考。

（一）胆的生理功能

1.胆的生理形态

《难经·四十二难》说：“胆附肝之短叶间，盛精汁三合”。这里我们可以理解到：①胆位于肝叶；②胆是一个能盛精汁的囊状物，“盛”有储藏的意思；③胆储藏的是“精汁”，故胆又叫“中清之腑”。“精汁”的来源，一说来源于肝，为肝之余气所生；一说来源于五脏，“他腑之所受者，皆至浊之物，而唯胆则受五脏之精汁也”（《黄帝内经灵枢集注》）。以上两说，证明了胆所盛的“精汁”，是与五脏有密切联系。正因为胆所盛的乃是“精汁”，因而既不同于五脏所藏的精气，也不同于六腑所盛的浊物，故有“奇恒之腑”之称。

2.胆的生理功能

①主决断：《素问·灵兰秘典论》说：“胆者，中正之官，决断出

焉。”所谓“中正”即不偏不倚的意思，所谓“决断”即是“刚正果决”，这说明了胆对人体精神情志活动具有“刚正果决”的能力，并且对外界事物能作出不偏不倚的客观反映，《灵枢·论勇》说：“勇者……其肝大以坚，其胆满以傍，怯士者……肝系缓，其胆不满而纵。”②主疏泄：肝的主要生理功能是疏泄，而胆也主疏泄。因为肝胆同应春生之气，肝为乙木，胆为甲木，肝为阴，胆为阳，两者一阴一阳，互相配偶，共主疏泄，肝胆互济，方成其用。胆又储藏精汁，是机体不可缺少的物质，它能资助脾胃的生化，促进饮食的消化与吸收。胆为少阳，少阳为三阳之枢，位于半表半里，行于身之侧，与手少阳三焦经密切联系，三焦为水火升降的道路，关系到人身的气化功能。可见肝主疏泄，而胆亦主疏泄，肝胆共主疏泄是无疑义的。

3.“凡十一脏，取决于胆”的意义

“凡十一脏，取决于胆”，见于《素问·六节藏象论》，是胆腑理论核心的体现，尽管历代医家，见仁见智，存在分歧。王冰以“中正刚断无私偏”为胆作释；李东垣以春升化安作解释；张景岳以“通达阴阳”为辨。我们认为：一方面应对胆的内涵吃透其基本精神；另一方面从五脏与胆的关系加以论证，紧密结合临床才有实际意义。我们的意见是：“凡十一脏取决于胆”的内涵有二：①五脏的神志活动取决于胆，五脏又有五神脏之称，如心藏神、肝藏魂、肺藏魄、肾藏志、脾藏意等等。人的神、魂、魄、意、志等精神情志活动，既要在心神的统率下进行，也要有胆的决断，使这些精神情志活动有一定的主见和选择能力。②疏泄五脏六腑气血：五脏皆有气血，气血皆有赖肝胆疏泄以为用，肝胆互为表里，共同疏泄气血，其中肝之疏泄所以不致太过或不及，是胆腑参与了调节的作用。张志聪说：“五脏六腑，共为十一，禀赋不同，情志各异，必资胆气，庶得各成其用。”正因为胆具有主决断、主疏泄的功能，因而胆对“十一脏”的影响也必然包括上述的两方面作用，所以肝胆的功用实不可偏废。

我们再从胆对五脏的生理、病理影响，看看十一脏取决于胆的实际意义。

以肝胆而言，张景岳说：“肝气虽强，非胆不断，肝胆互济，勇敢乃成”。《类经》又因为肝为厥阴，厥阴多厥热胜复，寒热兼见；胆为少阳，少阳为病多见寒热往来，故肝胆的病变，多有寒热互见之症。尤其是少阳为半表半里之枢，邪客胁下，逆其枢机，则见呕吐、胸满、口

苦、咽干、目眩等症。《伤寒论》治疗此证，以小柴胡汤和解少阳胆腑的邪气，后世医家根据肝胆同治的理论，发展了小柴胡汤的应用范围，在临床上广泛地治疗肝胆疾病，而取得了满意的疗效，这都是根据肝胆互为表里，互相影响这一共同病机而进行治疗的。

以胆与心而言：心主神明，胆主决断，决断功能的发挥是在“心主”的统率下进行的，否则，“主不明则十二官危”；另一方面，心属火，胆属木，木火相生，故心主的神明和主见的产生，又需要胆的决断而后现。《医学入门·脏腑总论》说的“心与胆通”，就是这个道理。在病理情况下，若情志之火内发，或气结湿生，化为痰浊，痰火互结，上扰心神，使心主神志的功能失调，通过清胆化痰，达到安定心神的作用。唐容川指出：“胆病战栗颠狂，宜补心为主。”（《医经精义·脏腑通治》）这种心与胆的辨证认识是很有见地的。

以胆与肺而言：肺主气司治节，为最高之脏，五脏六腑皆受其节制；少阳胆木亦受肺气制约；同样，因胆经上行注于肺，胆的疏泄对肺主治节，宣发肃降功能的发挥，亦有协同作用。在病理状态下，一脏有病，则彼此可以相互传变，尤其是胆气郁滞时，对肺的影响为大，故《素问·阴阳别论》云：“一阳发病，少气善咳”。《素问·咳论》亦云：“胆咳之状，咳呕胆汁”。

以胆与脾（胃）而言：肝胆脾胃，是人体气机升降出入运动的枢纽，必须保持其协调的统一。黄坤载说：“肝气宜升，胆火宜降，然非脾气之上行，则肝气不升，非胃气之下降，则胆火不降。”（引自《医学衷中参西录》）反之，在病理状态下，胆虚不能制脾，则易引起湿滞痰生，更明显表现为对胃降功能的影响，《素问·气厥论》说：“胃移热于胆，亦名食**飧**”。

以胆与肾而言：胆属火，肾属水，胆气通于肾，胆疏泄功能的发挥，有赖肾的滋养涵濡。在病理状态下，常出现胆肾同逆为病。《素问·阴阳别论》说：“二阴一阳发病，善胀、心满、善气”。所谓“二阴”即指少阴心肾，一阳即指少阳胆，王冰注曰：“肾胆同逆，三焦不行，气蓄于上故心满，下虚上盛故气泄出也。”因此，临床上亦常见肾病从胆论治，或肾胆同治的案例。

由上所述的内容可以看出，“凡十一脏，取决于胆”是有它的实际内容与指导治疗的意义。

（二）胆的病理特点

胆虽是腑，但泄中有藏，一方面协助六腑以传化物，另一方面疏泄精汁以助生化而贯彻上下，通行表里。沈金鳌说：“为肾之根而通乎下，应肺治节而通乎上，其所以能通乎上者，以其为中和之极也，惟通乎上下，故能游行三焦，且即三焦之所治，以致用阳明，故十一脏皆藉胆气以为和，经曰：少火生气，以少阳为嫩阳，为生气者也。”（《杂病源流犀烛·胆病源流》）因此，胆以清静宁谧为顺，以烦扰躁动为逆，调畅气机则顺，气机壅遏则逆。或为寒为热，或三焦失宜，或神志变异等等，诸证不一，其病理特点可概括为四：

1.寒热错杂互见

胆属少阳，少阳为一阳，乃阳之初生，其经脉行人身之侧位居半表半里之间，因此，若邪袭于胆，则可出现往来寒热一症。因正气出与邪争，故见发热，邪气入则恶寒，病位半在表，半在里，正邪纷争在此，是以寒热往来，交替而作。《灵枢·邪气脏腑病形》云：“胆病者……呕宿汁……善寒热者。”《伤寒论》也载有“寒热往来，胁下痞鞭”等症，可见往来寒热一症是胆病证的重要反映。

2.气机壅滞，郁结痰火

胆主疏泄，中寓相火，若疏泄失职，气机郁滞，致使相火不宁而发动，足少阳胆与手少阳三焦同名少阳，而三焦一经既是相火宣布的场所，又是水谷运行的道路，因此，胆病影响三焦气化，使相水不得宣行，气机郁结，水液不得通调，相火不得宁谧，则气机壅滞，痰火交结而为患，正如《重订通俗伤寒论》云：“足少阳胆与手少阳三焦合为一经，其气化一寄于胆中以化水谷，一发于三焦以行腠理，若受湿遏热郁，则三焦气机不畅，胆中相火乃炽。”

3.决断废弛，发生神志病变

胆主决断，若胆的疏泄失职，对人的决断作用废弛，从而使精神情志活动失常，然有轻重、寒热、虚实的不同程度，如虚则寒，寒则恐惧，头眩不能独卧；实则热，热则惊怖，精神不宁，卧则不宁。若痰火上扰，迫使相火不藏，肝魂不宁则易惊多梦，甚则上扰心神，出现不寐，或狂癫等症。《灵枢·邪气脏腑病形》说：“胆病者，善太息，心中澹澹然，恐人将捕之，中訿訿然数唾。”这里“澹澹”即动荡貌，訿訿似指咽喉如有物阻塞，类似于现代所指的“歇斯底里”发作的病状。

4.干扰他脏为患

“十一脏取决于胆”，所以胆腑有病，必然影响其他脏腑。例如：胆火扰心，则心悸心慌；痰热扰肝，则咳呕痰涎苦汁；胆火上逆，清阳被遏，脾胃不和则见食欲不振，纳谷不化；痰热迫胃，胃失和降，则呕吐痰涎酸水；若痰火上扰，气机升降失司，而又阴虚阳亢，则胆之气同逆，可见头晕，心中懊恼欲呕，腰酸腿膝乏力等症，若胆腑之热波及阳明胃家，亦可出现心下急，郁郁微烦，呕不止等症。

由上所述，胆腑病变规律可分为：①胆失疏泄，气机阻遏，发为痰火交结等证。②胆的决断功能废弛不用，可发生各种神志疾患。这些病理特点，为临床治疗提供了辨证依据。

（三）胆病的证治规律

因为胆贵疏泄通降，胆腑以通为顺，故治疗胆腑疾病，应以通降为主，可根据寒热的孰轻孰重，分别予以和胆、温胆、清胆、利胆等法进行治疗，切勿滥用补剂以壅滞其气机而留邪为患。现将其证治规律叙述如下：

1.外邪客胆

（1）邪客胆之经腑，病位在半表半里

症状：往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，脉弦，苔白滑。

证候分析：邪客少阳之经，邪正交争于半表半里，所以往来寒热。胸胁是少阳经所司之位，邪壅而少阳经气不利，故胸胁苦满。邪客少阳，则胆腑气郁，疏泄不利，影响于胃，故精神嘿嘿不欲饮食。热郁于胆则烦，气逆于胃则呕，故见心烦喜呕之证。若邪热郁于胆腑，胆汁上溢，则见口苦，胆汁外溢，也可发生黄疸。弦主肝胆病，舌苔白滑主热在少阳未入阳明。

治法：和解少阳，清热利胆。

方药：柴胡12克，黄芩10克，党参6克，炙甘草6克，半夏9克，大枣4枚，金钱草15克，虎杖10克，垂盆草12克。

方义：柴胡气质轻清，苦味最薄，善疏解胆腑之热又能开其郁滞，配黄芩之苦寒，以清胆热，则烦满可除；半夏、生姜调理胃气以止呕；人参、大枣、甘草益气和中以养正，扶正寓祛邪之意；金钱草、虎杖、垂盆草善清肝胆邪热。数药相伍可有条达上下，宣通内外，运行气血和清解郁热之功。

【按语】

上方为小柴胡汤的加味法。小柴胡汤能治疗急慢性胆囊炎，或急慢性肝炎，如见上述证候，用之均有显效。若是胆结石患者可加重金钱草，佐入枳壳、郁金、鸡内金以增其清热排石之力。使用本方时，柴胡用量应大于人参、甘草一倍以上，方能发挥其清热透邪，和解表里的作用。

（2）邪郁胆腑，热结在里

症状：胸胁苦满，心下急，呕不止，郁郁微烦，大便不通，舌苔黄腻，脉弦而有力。

证候分析：胸胁苦满，为邪郁于胆之征，又见胃脘急迫，或疼或满，使人难耐而又呕不止、郁郁微烦，则气火交阻于里，故大便不通，舌苔黄腻，脉弦有力是其候矣。

治法：清热利胆，通腑泄热。

方药：大柴胡汤。

柴胡12克，黄芩10克，大黄6克（后下），枳实9克，半夏9克，白芍9克，生姜12克，大枣4枚。

方义：本方即小柴胡汤去人参、甘草，加枳实、大黄、芍药而成。去人参、甘草因里气实，恐补而留邪也。加枳实、大黄、芍药之酸苦走泻之品，以荡涤热邪之结。

【按语】

本方治疗急性胆囊炎而见上述证候者，可加入郁金、青皮，效果更佳。对于急性胰腺炎，亦同样有效。

（3）胆腑邪热，内迫肠胃

症状：身热，口渴，口苦胁痛，干呕心烦，或泄泻，或下利赤白，尿少而黄，舌苔黄，脉弦数。

证候分析：热客少阳胆腑，胆热外蒸，胆气上逆，是以身热、口渴、口苦而胁痛；若下迫大肠，津液下注，故泄泻；若热邪挟湿，则下利赤白，尿少而黄；热邪上迫胃腑，故干呕而烦，至于舌苔黄，脉弦数，则为少阳胆腑热郁之象。

治法：清泄郁热，疏利胆道。

方药：黄连黄芩汤。

黄连10克，黄芩10克，郁金6克，豆豉9克，白芍12克。

方义：本方系吴鞠通从《伤寒论》黄芩汤加减衍化而来。方中以黄芩、黄连之苦寒，清利胆腑之郁热；郁金辛寒，以疏胆腑之滞；豆豉性寒体轻，而能宣达郁热；白芍一味则平肝和阴之用。

【按语】

干呕口苦而渴，系热郁少阳胆经所致，这是本证的辨证眼目。本方用于慢性胆囊炎而见上述证候者，有一定疗效。

（4）湿郁蕴结胆腑

症状：寒热似疟，午后较甚，入暮尤剧，天明得汗稍减，口渴心烦，脘痞苔腻，呕恶，口苦，脉滑数。

证候分析：湿热蕴滞，胆失疏泄，邪正交争，互有进退，故发热而又恶寒，其形如疟；因热中有湿，湿为阴邪，故午后及入暮为剧；胆汁上逆，故口苦；邪热伤津，则咽干口渴，湿热阻滞气机不利，故脘痞而苔腻；湿郁于里，胃失和降，则见呕恶。平旦之时，阳气旺盛而能胜邪，故可得汗而症状稍减，至于舌苔黄腻、脉滑数，皆为湿热内停之象。

治法：清泄胆腑，分消湿热。

方药：蒿芩清胆汤。

青蒿9克，竹茹9克，法半夏5克，赤茯苓9克，黄芩10克，枳壳6

克，陈皮6克，碧玉散10克（布包）。

方义：本方以青蒿清透胆热之邪于外，以黄芩清胆热之邪于内，竹茹清郁火，又能化痰和胃。由于湿化为痰，胃气不和，故又以枳壳与二陈汤合用以专其治。用碧玉散的意思，是清利三焦之湿热，使从小便而出。何秀山说：“此为和解胆经之良方，凡胸痞作呕，寒热如疟者，投之无不效。”

【案例一】

尹某，男，34岁。胸胁发满，夜睡呓语不休，且乱梦纷纭，时发惊怖，精神不安，自汗出，大便不爽，既往有癫痫病史，此病得于惊吓之余。视其人神情呆滞，面色发青，舌红，苔白黄相兼，脉来沉弦，辨为肝胆气郁，兼阳明腑热，心神被扰，不得潜敛之证，治宜疏肝泻胃，镇惊安神。处方：铅丹5克（布包），大黄6克（后下），茯神9克，柴胡12克，黄芩9克，半夏9克，生姜9克，龙骨15克，牡蛎15克，桂枝4.5克，大枣6枚。服一剂大便畅通，胸胁满与呓语皆除，精神安定，不复梦扰，惟欲吐不吐，胃中似嘈不适，上方加竹茹、陈皮，服之而愈。

【案例二】

李某，女，54岁。右胁疼痛，掣及胃脘，不可忍耐，惟注射“杜冷丁”方能不痛。视其人体肥，面颊绯红，舌质红绛，舌根黄腻，脉沉滑有力。问其大便已四日未解。口苦时呕，不能饮食。西医有的诊为胆囊炎，有的诊为胆结石。余认为症见胁痛而大便不通，口苦而呕，舌苔黄腻，脉来弦滑，乃肝胃气火交郁，气血阻塞不通，不通则痛，而为甚。治宜两解肝胃，泻热导滞。处方：柴胡18克，黄芩9克，半夏9克，生姜12克，白芍9克，郁金9克，大黄9克，枳实9克，陈皮12克，生牡蛎12克，煎汤，分三次服。一服疼痛减轻得睡，二服，大便解下一次，从此胁痛与呕俱解，转用调理肝胃药而安。

【按语】

案一诊为肝胆气郁，肝郁则魂不潜，胆郁则决断不能，更兼阳明腑热，上扰心神，心主亦不明，是以柴胡加龙骨牡蛎汤，疏肝胆之郁，泻胃家之热，即达到镇惊安神之效。案二系胆腑有积热停瘀，气火交郁，阻塞不通，用大柴胡汤两解肝胃，泻热导滞，一服即见效机，再服胁痛与呕俱解，可见柴胡剂对胆腑病变应用甚为广泛。临床还常用柴胡加芒

硝汤，治柴胡证而兼肠中燥屎者，其效果也好。胆以通为顺，不通则痛，故常与大便秘结同时出现，所以治用泻热导滞之法，使邪有出路而不壅滞，确系治疗胆病疼痛的必备之法。在这里有必要介绍一下《伤寒论》用刺期门法或用小柴胡汤治疗热入血室之证。“血室”历来在认识上是有争议的，有人指太冲脉为血室，有人指肝脏为血室，也有人指子宫为血室。我们认为以上三种说法，如能联系而论为最好，因为子宫、肝脏、冲脉，统属于厥阴经的范畴，所谓主冲脉者，是指血的源头而言，所谓主肝者，乃就其藏象所处而论，所谓主子宫者是就月经流行之地而谈。这就说明了血室的内容是肝经血分的各个所系之地。热入血室多与经水适来或适断有关，说明了它与月经的关系非常紧密，故有女子以肝为先天之说。

热入血室的主症是：发热恶寒，胸胁苦满如结胸状，经水适来或适断，或昼日明了，暮则谵语如见鬼状。其病机是：因经水适来或适断，邪热乘虚而入，热与血搏，其血必结，浅则邪留少阳，故寒热往来如疟，深则邪结厥阴，则热深厥深。若邪热上扰心神，或肝神不能戢敛，故昼日明了，暮则谵语如见鬼状。《类证普济本事方》云：“……遇经水适来或适断，邪气乘虚而入血室，血为邪迫，上入肝经，肝经受邪，则谵语如见鬼状……”肝脉布两胁，邪滞肝脉，邪热与血搏结而不行，故胸胁满如结胸状。

热入血室用小柴胡汤与刺期门法治疗的意义，正是体现了病气浅深不同的治法。章虚谷说：“肝胆为表里，故深则从肝，浅则从胆，以导泻血室之邪也。”所谓浅，是指邪留少阳；所谓深，是指邪结厥阴。因为热入血室，与胃肠无涉，故不应下；病亦不在表，故不应汗；胸膈无邪，又不能吐。汗吐下皆不可施，故庞安常说：“先宜小柴胡汤，不差，可刺期门。”故浅者用小柴胡汤和解，深者刺厥阴肝经募穴——期门以泄邪热。兹录许学士治案一则加以印证。

许学士治一妇病伤寒，发寒热，遇夜则如见鬼状，经六七日，忽然昏塞，涎响如引锯，牙关紧闭，瞑目不知人，病势危困，许视之曰：“得病之初，曾值月经来否，其家云：经水方来，病作而经遂止，得一二日，发寒热，昼静而夜则有如鬼祟，从昨日不省人事。许曰：此乃热入血室症。仲景云：妇人中风，发热恶寒，经水适来，昼则明了，暮则谵语，如见鬼状，发作有时，此名热入血室。医者不晓，以刚剂与之，遂致胸膈不利，涎潮上脘，喘急息高，昏冒不知人，当先化其痰，缓除其热，乃急以“一呷散”投之，两时顷，涎下得睡，省人事，次投以小柴胡汤加生地，三服而热除，不汗而自解矣。（《名医类案》卷十一）

【案例】

本案诊为热入血室，先以一呷散以去其痰，次以小柴胡汤加生地凉血解热而愈，然而，热入血室偏于血热者，也并非小柴胡汤所宜，《临证指南医案》所有热入血室案，无一例用小柴胡汤的记载，这一方面虽与叶氏的“柴胡劫肝阴”，视柴胡汤如仇敌的偏见有关，但另一方面对邪结厥阴，血热而邪深的患者，也确非所宜。其解决的办法是：邪浅而体不虚，小柴胡汤当减去参、姜、枣、草，以免留邪，适当佐入凉血散血之品，使血分松动流通，不与热结则邪可自散。对于邪热深结厥阴的患者，宜遵王孟英之说：“经水适来，因热邪陷入而搏结不行者，此宜攻其血结，若经水适断，而邪乃乘血舍之空虚以袭之者，宜养营清热，其热邪传营迫血妄行，致经来当期而至者，宜清热以安营。”

2.痰热内扰

胆寄相火，内通三焦气化，但又禀气于胃，而成后天之本。若胆失和降，气机郁滞，相火肆虐，胃虚则水谷不化精微聚湿而成痰，痰火胶结则痰热内扰。痰热内扰从其发病规律来看，往往出现化火、伤阴、动风等证，如痰盛可以化热，气郁可以化火，化火自能伤阴，伤阴必然阳亢，阳亢则变化而动风。而且，病理变化常由胆波及肝，抑或肝胆同病而彼此呼应。

（1）痰热内扰，胆胃不和

症状：头晕目眩，口苦，呕恶痰涎，烦躁不寐，惊悸不宁，胸闷，善太息，时有幻闻，幻视，舌红苔黄腻，脉弦滑等症。

证候分析：本证由痰热内扰，胆胃不和而起，口苦为胆热之征，痰热迫使胃气上逆，则呕恶痰涎；胆脉络头目，痰浊循经上扰，故头晕目眩；痰热内扰肝魂，故烦躁不寐，惊悸不宁；痰浊阻滞，胆失疏泄，故胸闷善太息；神明失守，痰热上迷，故可见幻视、幻闻、幻觉的“三幻”证候，舌质红为有热，苔黄腻为痰湿不化，脉弦滑为痰热郁阻。

治法：清胆、和胃、化痰。

方药：黄连温胆汤。

半夏9克，陈皮9克，茯苓9克，生姜6克，炙甘草6克，竹茹9克，枳实9克，黄连6克。

方义：《备急千金要方》载温胆汤方治“大病后虚烦不得眠”之症。罗谦甫说：“方以‘二陈’治一切痰饮，加竹茹以清热，加生姜以止呕，加枳实以破逆，相济相须，虽不治胆而胆自和，盖所谓胆之痰热去故也。命名温者，乃温和之温，非谓温凉之温也……不但方中无温胆之品，且反有凉胃之药也。”

【案例】

杨某，女，59岁。病已5年，屡治无效。自称其右侧唇与舌感觉热而麻辣，如涂辣椒末，而左侧的唇舌，则觉寒凉如冰，冷彻肌肉，其人殊肥，面色黧黑。每晨起必先呕吐痰涎，亦无以为常。问其睡眠，则少

寐多梦，且心悸而易惊，六脉弦滑，舌无异常，惟苔则白腻。此为胆经痰热证，所谓“怪病多痰”是矣。审其晨起呕吐痰涎，脉滑面黧，属痰热之证似无可疑，用温胆汤加胆星、竹沥、黛蛤散同煎，服至六剂，不但舌唇之异常感觉消失，其他诸证亦随之而愈。

【按语】

“怪病多痰”。此证乃肝胆郁热，蒸变脾湿而为痰，是以用清肝胆痰热之药，是伏其所主也。二年怪病，竟六剂后而若失，可见辨证之要，贵在准确无误。

为此，临证时还要分清是痰偏盛，还是热偏盛。若痰偏盛，表现头目眩晕为主；胃中痞满，呕吐痰涎不止，见于肥胖体质；舌苔厚腻，脉弦滑，可于黄连温胆汤中，加入胆南星、竹茹、海蛤、青黛、海浮石等清化痰热之品；若热偏盛的，表现为口苦较重，心烦而躁，小便黄赤，舌质绛而苔黄，脉弦滑数，可于黄连温胆汤中，加入山栀、黄芩、连翘、竹叶等清心解热之药。

（2）痰热内扰，气郁不伸

症状：痰热内扰，更兼心胸憋闷，噫气不畅，叹息觉舒，舌红苔腻，脉沉弦。

证候分析：气郁则内热，热郁则痰生，气、痰、热交郁，因为痰阻气滞，故心胸憋闷，噫气不畅，叹息觉舒；舌红主内热，苔腻主痰湿，脉沉弦主气郁不伸。

治法：清胆化痰，佐以理气。

方药：温胆汤，加柴胡10克，香附10克，郁金9克，佛手9克，橘叶12克。

方义：方中以温胆汤清化痰热，柴胡疏肝，香附理气，佛手、橘叶理气化痰，郁金清血分之滞，又能疏肝解郁。

【案例】

张某，女，32岁。得病原因，由于惊吓。心胸憋闷且慌，时有气冲，如上至心胸，则觉心中忙乱难忍，必须跑出屋外，大喊几声方安。睡眠不佳，多做噩梦，胆小善畏，情志郁而不伸，六脉沉弦，舌红而苔白。

此证脉沉弦，主肝气抑郁，古人说：六郁多沉，而弦主肝胆。肝气上冲心胸，则心中为之忙乱，跑出屋外，大喊几声，使气郁得伸故安。寐多且多噩梦，又胆小善畏，乃气郁生痰而神魂为之不安。治法：疏肝豁痰，解郁理气。以温胆汤原方，另加香附、郁金、青皮、陈皮、丹皮、白芍、蒺藜、菖蒲、土贝母等药，服二十余剂，其病逐渐获愈。

【按语】

证属肝郁，痰火内扰，是以疏肝解郁，清化热痰而获效。

（3）痰热内扰，阴虚已显

症状：痰热内扰，更兼五心烦热，或低热持续不退，日晡面部烘热，头晕耳鸣，舌质红绛，苔薄黄，脉弦滑。

证候分析：阴虚则内热，故五心烦热，或低热持续不退；阴虚则潮热，故日晡面部烘热；肝肾阴虚，故头晕耳鸣，舌质红绛主阴虚，脉弦滑主痰热内盛。本证多痰热内扰，继而伤阴，故既见痰热内扰之证，又见阴虚之状。

治法：清化痰热，佐以滋肾养阴。

方药：温胆汤加丹皮、地骨皮、青蒿、生地、白芍、龟板。

方义：方中以温胆汤清化痰热，生地、白芍、龟板养阴，丹皮凉血，地骨皮、青蒿以养阴透热。

（4）痰热内扰，阴虚阳亢

症状：在痰热内扰之症的基础上，更表现头目眩晕，或头痛而胀，面红目赤，性急易怒，耳鸣如潮，下肢无力，舌绛苔黄，脉滑大充盈有力。

证候分析：肝胆互为表里，痰热内扰，可伤及肝阴，以致阴虚阳亢。阳亢于上，故头晕目眩，或头痛而胀，面红目赤；阴虚于下，则下肢无力。肝阴虚而气郁不伸，故性急易怒；阴虚火旺，故耳鸣如潮。舌绛苔黄主阴虚有热，脉滑大充盈有力，主阴虚阳亢痰盛。

治法：清化痰热，平肝潜阳。

方药：温胆汤加龙胆草、夏枯草、益母草、石决明、珍珠母、丹皮、白芍、牛膝、桑寄生。

方义：本方肝胆同治，方中以温胆汤清化痰热，以龙胆草、夏枯草清肝热；以益母草、石决明、珍珠母平肝潜阳；丹皮凉血；白芍、牛膝、桑寄生滋阴和阳。

（5）痰热内扰，肝风内动

症状：既见痰热内扰之症，又见头目眩晕，肢体窜痛或麻木，皮内如有虫行，或肩背掣痛，或肢颤口眼喎斜，或突发癫痫，手足抽搐，口吐白沫，人事不知，舌红而脉弦细。

证候分析：既见痰热内扰，又见肝风内动，风助火势，火借风威，痰由热生，风由火化，是以见症如上。

治法：清化痰热，养血平肝熄风。

方药：温胆汤加羚羊角、钩藤、络石藤、当归、白芍、红花、茜草、熟地。

方义：方以温胆汤清胆化痰，羚羊角、钩藤平肝熄风；当归、白芍、熟地柔肝养血以熄风；络石藤通络熄风；红花、茜草活血，因血行则风自灭也。

【案例一】

王某，女，30岁。经常头痛且胆小善畏，如一人居，辄幻见满室杂坐老幼，集而向之笑，惊骇之余，毛发皆耸，移时而所见之人杳然无踪，为此必挽其夫在家为伴，经常失眠，而多噩梦，头痛掣目，心烦口苦，其脉滑数，舌质绛而苔黄厚。

脉滑主痰，苔黄厚亦主痰热，口苦心烦，头晕目痛，掣及目珠，皆肝胆痰火上逆之气，肝胆之邪乱于神志，清虚之窍受蒙，神魂为之拂乱，故见心烦、少寐、多噩梦，而又有“幻见”，笑为心之声，属痰火内动其性。

治当清化痰热，兼平肝宁心为法。用温胆汤原方，加栀子、黄芩、黄连、夏枯草、蒺藜、龙骨、牡蛎、白芍。加减进退，约服十余剂而愈。

【案例二】

李某，女，34岁。患病三载，睡眠不佳，多梦易惊，精神恍惚失

常。曾裁剪衣料，持剪直下，衣料裁废，方始知悔，其动作每多如此。与人言则喋喋不休，易悲易哭，不能控制。有时全身发热，自觉有一股风气，在皮肤中走窜，忽上忽下，尤以肩膊为明显。两手颤抖，四肢发麻，口苦多涎，脉弦细，舌边尖红绛，苔白。

证属肝胆痰热，日久伤阴动风。口苦多涎，寐少梦多，惊畏而精神恍惚，举止失常，反映了痰热扰心，神志不安，自觉风气走窜，四肢发麻，两手颤抖，脉弦而细，又主虚风动，络脉失养之象。治宜清痰热，养血熄风。用温胆汤原方，另加当归、白芍、何首乌、桑寄生、红花、桃仁、全蝎、僵蚕、钩藤等药，服三十余剂，逐渐痊愈。

【按语】

胆病用此法，而肝病亦可用此法，肝胆为病，每相合而来，故举一反三，存乎其人。

三、肝病用药指归

“用药如用兵”，向来为医家所重视，医师临证用药，就好像军事家临战用兵，要“知人善任”，善于调遣。怎样才能做到善于遣药用方呢？首先，明辨药物五味之情。《素问·至真要大论》云：“五味入胃，各归所喜，故酸先入肝，苦先入心……”饮食五味各归其所喜，药物五味亦有所喜攻，如辛散、甘缓、酸收、咸软、苦泻。因此，明辨药物五味，即是用药物五味之性去纠正脏腑阴阳气血之偏。

其次，分别五脏苦欲补泻。五脏苦欲补泻，出自《素问·脏气法时论》，五脏的苦欲为好恶，违其性故苦，遂其性故欲。欲者是其所好，即补之，苦者是其所恶，即泻之。

既明药物五味之性，又辨明五脏苦欲之理，并结合脏腑寒热虚实的不同程度，以温凉补泻药物来纠正其偏，这就是脏腑辨证用药规律，肝病用药亦毫不例外。

脏腑辨证用药，最早见于张元素的《脏腑标本寒热虚实用药式》，以虚实标本为纲，以补泻温凉为目，来归纳用药，这不但丰富了脏腑辨证的内容，而且能使临床医生执简驭繁地掌握药物的效用，直接提高临床疗效。后来的医家又大有发展。

肝病辨证用药，除了张元素的《脏腑标本寒热虚实用药式》以外，李时珍的《本草纲目》所列“脏腑标本寒热用药式”沿用了张氏之说，其肝病用药竟达70多种，张山雷后来在“脏腑药式补正”中又作了补充，《本经分经审治》也有新的发挥，并以补、散、寒、温、攻、和六类以统之，他如李冠仙、黄宫绣、叶天士、王旭高等皆有建树，说明历代医家对肝病用药分类是比较重视的。

但是，由于药物的性味和功能的复杂性，往往有一药而多能，既能治此脏，又能治彼脏，因而历代医家对肝病用药未有统一意见。为了便于读者更好地掌握肝病用药法度，我们依据历代医家比较统一的意见，结合我们个人的临床体会，整理归纳，附于篇后，以备查考。

（一）补肝药队

“虚则补之”，凡质厚、味纯，气浓，具有纠正肝脏气血阴阳功能不足的药物，叫做补肝药。以前的补肝药，比较局限于补肝血（或滋肝阴），随着肝病研究的深入，我们对补肝气和补肝阳的药物，适当做了一些调整和补充。

1.补肝气

肝以气为用，气强用强，气虚用怯。如肝气虚，木能遂其生、升之性，气血不能上达巅顶，可出现：头重如裹，目眊眊不能久视，或善太息，精神不畅等症。治疗此症，宜遵“气虚则掣引之”的原则，运用温升益气之品资助肝气，以助肝用。

（1）黄芪：

甘、微温，归脾、肺经。因其色黄，且具有补气之长，故名曰黄芪。诸家本草只知本品补脾肺之气有显著疗效，但不知其温、升之性于补肝气尤捷。张锡纯体会较深，他说：“肝属木而应春，其气温而性喜条达，黄芪之性温而上升，以之补肝原有同气相求之妙用。”（《医学衷中参西录》）这里“同气相求”，意思是说以黄芪之甘温补气，以助肝之生、升之用。其实，《神农本草经》早就指出：黄芪主大风。其治风的机理无疑是与补肝密切相关。在临床上，运用黄芪，其功用可随不同配伍而发生不同的效果。如：与发表药同用，能散外风；与养阴清热药同用，能散内风；与补血药同用，能敛痈疽败疮；与利尿药同用能通利小便；与化瘀药同用，能起偏枯不遂之症。凡此等等，黄芪其所以有此功用，在一定程度上是通过补肝气，使气血疏泄调畅，达到活血、熄风、生肌敛疮、利小便的目的。不过，因黄芪性温升，具有壅滞气机之弊，所以临床应用时，可配合陈皮等理气之品，以疏通气机，使其补而不壅。

（2）山茱萸：

甘、酸、温，归肝、肾经。本品性温补气，味酸入肝补肝。补气之中具有通利气血之用，酸敛之中又有调畅之能，是以不呆补，不单敛。《别录》云其通九窍，张锡纯则更有所发挥，云：“其性不但补肝，而兼能通利气血可知。”（《医学衷中参西录》）张氏不但用其治疗腰膝

酸软、阳痿、尿频、遗溺，甚则中气下陷等症，而且用于因肝气虚衰欲脱之症。黄宫绣列本品为补肝之品，其说可从。

（3）杜仲：

甘、温，归肝、肾经。多数本草专著认为本品补肾，而不知其补肝气，唯《本经》云：“主腰脊痛，补中益精气，坚筋骨。”因其甘温，重在补中益气，而其专入肝、肾二经，故补肝肾之气是其所长，且“精化于气”。有云本品补肾精，但其补肾精是通过补肝气来实现的，故王旭高、黄宫绣皆以之作为补肝气药。凡头昏、耳鸣、腰酸、夜间多尿等症，用之尤宜。

（4）金毛狗脊：

苦、甘、温，归肝、肾经。本品的主要功能是：补肝肾，强腰脊。张山雷说：“金毛狗脊，生意最富，经久不枯，通利关节，故善治腰脊之痿弱。”“诸筋者皆属于节”，关节是诸筋汇合之处，而肝主筋，肝气虚则筋不能动或不能用，筋不能动则关节屈伸不利，所以强腰脊、通关节应补肝气，助肝生、升疏泄之用，使关节利、腰脊强。因此，我们把本品列入补肝气之品，黄宫绣谓其能补肝血，可供参考。

（5）续断：

苦、温，归肝、肾经。苦能坚能降，温能补能行。《大明本草》云：“助肝气，调血脉，补五劳七伤，破癥结瘀血。”因其能调畅血脉，故能破癥结瘀血。因其能助气，所以补五劳七伤。因此可以说：本品补中有通，温中有化，尤其是肝气虚衰时，因本品作为补肝气之品，确是恰到好处。无怪王旭高、黄宫绣皆将其列为补肝气药队。他如羊肝、大枣、鸡肉、人参均有补肝气之长，用于食养亦佳。

2.补肝阳

凡归经入肝，药性偏温，药味微酸，或配伍后具有温补肝阳作用的药物，皆属补肝阳药。由于“阳虚生内寒”，肝虚则生寒（《圣惠方》），所以肝阳不足易见一派虚寒之象，诸如“肝阳虚则筋无力，恶风，善惊惕，囊冷，阴湿，饥不欲食”（《蒲辅周医疗经验集》），皆

属肝阳虚衰，治宜温补肝阳。

（1）木瓜：

酸、温，归肝、脾经。本品药味至酸入肝，性味温而助阳，故列入补肝阳药队。凡肝阳不足，筋脉失养，或寒凝血虚所致转筋，寒湿脚气，皆当选用。江笔花以本品列入补肝药队次药之中。

（2）沙苑蒺藜：

甘、温，入肝、肾经。本品味甘而温，略带涩性，功能重在补益肝肾，张山雷列为补肝要药。因其温中带涩，对肝阳不足，肾阳虚衰之证，如阳痿、遗精、消渴诸疾，皆有较好疗效。

（3）菟丝子：

辛、甘、平，归肝、肾经。本品归肝肾二经，因其温而不燥，“益气力……久服明目”（《本经》），为其所长。本品以补肝阳为主，张山雷、黄宫绣皆将之列为补肝药队。《千金方》以本品配伍熟地、车前子，制成驻景丸，用以治疗肝阳不足，目视不明等症。肝开窍于目，目视不明皆与肝失疏泄有关。

（4）肉苁蓉：

甘、咸、温，归肾、大肠经。一般补阳药多燥，滋阴药多腻，而欲补肝阳只宜温润，辛燥则易伤肝阴。本品甘而微温，咸而质润，补肝阳而不燥，温肾阳而不寒，是以肝肾同补，在补肾阳之中，达到补肝阳的目的。

不少医家有“肝无补法”之论，致使温补肝阳药物的研究更乏其人。我们临床体会到，不但肝有补法，而且凡微温微酸专入肝经诸品，皆可作为温肝补肝之药选用。诸如：淫羊藿、仙茅、五味子、巴戟天、蛤蚧等，因限于篇幅，这里不多介绍。

3.养肝血

肝藏血，赖血充其体，敛气以柔其用。若肝血不足，肝体不充，血不制气，不能柔其体而反刚，可致多种病证。诸如头晕、面白、眼花、指甲及舌质色淡、少华、妇女月经量少，或停经等，是临床最常见的症状，治宜遵照“血虚宜濡养”的原则，作补养肝血之治。

（1）当归：

甘、辛、温，归肝、心、脾经。药名当归，是说本品既善补血活血，以其辛香善走，善通气分，使气血各有所归，故名。本品能升能降，能补能动，故用治血滞、血瘀、血枯诸证，尤以补肝血为其所长，因肝藏血，血虚多有所滞，本品能补肝血而行肝滞，例如与白芍、甘草同用以柔肝止痛；与红花、桃仁同用以疏肝化瘀；与党参、黄芪同用以补气生血；张锡纯谓“其能生血即能滋阴”，是属于推理之论，不能轻信，因本品毕竟辛散温通，气火偏盛者仍宜慎用之。

（2）何首乌：

甘、苦、涩、微温，归肝、心、肾经。发为血之余，发黑则血气盛，发白则血气虚，因其补肝血力胜，能乌须发，故名。《本草纲目》云：“养血益肝，固精益肾，健筋骨，乌须发，为滋补良药。不寒不燥，功在地黄、天门冬之上。”本品滋而不腻，补而不滞，江笔花、王旭高、黄宫绣皆推其为补肝血之上品，益信其价值。

（3）阿胶：

甘、平，归肺、肝、肾经。胶类品种甚多，鹿、龟、鳖诸胶皆腻，唯本品最为平和，甘平而能润肺燥，质粘而能养肾水，然其所贵之处，仍以补养肝血为尤胜。但温肾不及鹿角胶，潜阳不及龟板胶，滋阴不及鳖甲胶，补脾不及露天胶。因其黏腻，善于凝固血络，故又有止血之功。但毕竟属黏腻之品，脾胃虚弱者忌用，即便是实热或挟有瘀滞的患者，也不要早用，早用反有留瘀之弊。

（4）鸡血藤：

辛、甘、温，归肝经。甘缓能补，辛散能通，专入肝经，养血活血，善养善行，能补能通。《纲目拾遗》云：“治老人气血虚弱，手足麻木，瘫痪等症；男子虚损，不能生育及遗精白浊；男妇胃寒痛，妇女经水不调，赤白带下，妇女干血劳及子宫虚冷不受胎。”其应用范围之广，皆用其补肝血之故。若取汁熬膏，名曰“鸡血藤胶”其力尤胜，于老人、妇人尤为适宜。

（5）熟地：

甘、微温，归心、肝、肾经。熟地甘温，滋阴补肾，因其能滋肾，通过滋肾而达养肝目的，故多数本草书列为补血药类。且在滋养肝血方中，经常使用，但因其质柔润，对脾弱有湿及痰多气郁患者，皆不宜用。必要时亦可与理气及芳香健胃药同用，以防其滋腻。与首乌相比，滋阴之力稍胜。

4.滋肝阴

凡药性甘凉、甘平、甘寒、或甘咸，具有滋养肝阴，柔和肝体等功能的药物，称为滋肝阴药。肝体阴而用阳，若肝体不足，阴血亏损，可见头晕，两目干涩发蒙，口干便结，舌绛少苔等症，治宜滋养肝阴。因肝肾精血同源，故滋肾阴之品，又多有养肝阴之力，是以历代医家未作严格划分，我们根据临床体会，归纳几种主要药物，介绍如下。

（1）白芍：

苦、酸、微寒，归肝经。因其味酸，善敛摄肝脏自动之风阳；因其味苦，苦能泄热，能入胆而益胆汁，且平肝阳之上亢；因其微寒，善泻肝胆之热以疗痢疾后重，但护养肝阳之力为其所长。如平肝与石决明、钩藤同用；补肝血常与当归配伍；疏肝气常与青皮、柴胡同施；消瘀血常与桃仁、红花同配；其配伍之用，皆取其酸入肝，有护阴之长，临床运用时，宜与赤芍鉴别。

（2）黄精：

甘、平，归肺、肾、脾经。甘者缓之，甘缓以疗肝苦急之证，其作用有二：一是填精，补肾精益肝血，《本草纲目》云：“补诸虚……填

精髓；二是益气，五脏诸虚皆可用之，《别录》谓其“补中益气……安五脏”，一物而兼两能，填精而不腻，益气而不燥，既双补气血，又调理脾胃，诚为滋养之上品。

（3）女贞子：

甘、苦、凉，归肝、肾经。本品甘苦性凉，补中有清，补而不腻，清而不寒，既滋肾水，又养肝阴，尤为补肝肾要药。临床用于肝病眩晕、耳鸣、腰膝酸软等症。《本草纲目》谓其：“强阴，健腰膝，变白发，明目”。与旱莲草配伍，方名二至丸，成为养阴名方，其养阴之力，不在地黄以下。

（4）枸杞：

甘、平，入肝、肾经。枸杞偏温还是偏凉，对此历代医家有争议。有人谓其能兴阳道，性偏温；王旭高、张山雷谓其善补肝阴，善养肝木。考其味甘多液，滋补肝肾之阴尤良；性偏微凉，退阴虚潮热之证弥佳。张锡纯云：“惟枸杞能补益元阴，与先天之元阳相济，是以有此功效。”（《医学衷中参西录》）确诊为阴虚发热，其退热之功甚宏。但与其根地骨皮效用有别，地骨皮性凉而长于退热，本品则性微凉而偏于滋阴，临床应用宜加鉴别。

（5）生地黄：

甘、苦、寒，归心、肝、肾经。其味甘缓滋阴生津，味苦而清热凉血，且甘重于苦，尤以滋阴养血为长，对于阴虚阳亢，血虚风燥，心烦内热等症，具有卓效。品种有鲜、干两种，以干生地多用于滋阴，熟地黄甘而不苦，更长于滋阴，但本品苦而兼寒，又能生血凉血，故临床常生熟地同用。

（6）黑芝麻：

甘、平，入脾、肺、肝、肾经。黑芝麻与大胡麻功能相近。芝麻甘平多脂，润燥滋阴，对于肝肾阴亏，血燥生风所致头晕目眩、耳鸣、肢麻等症，药食咸宜。大胡麻性甘微温，柔养肝木，熄风潜阳，临床上可互代。张山雷说：芝麻“脂液尤多，润泽妙品”，“胡麻柔润，能养液以柔肝木，故亦可为熄风潜阳之药。”

他如乌梅、人乳等亦属滋肝之品，临床可随证选用。

（二）抑肝药队（包括平肝镇肝）

抑肝药是指遵照“高者抑之”，“惊者平之”的原则，运用抑降药物以抑制肝胆升浮之火，或用甘寒、咸寒、辛甘以平降肝气之横逆，或用金石矿类以潜镇肝阳的药物，统称抑肝药。若细分之，抑肝、镇肝、平肝又略有区别：抑肝宜于肝气上逆，平肝宜于肝气横逆上扰，但化火动风不明显，镇肝宜于肝阳化火动风，因其总的作用相近，故归在一起讨论。

（1）菊花：

辛、甘、苦、微寒，归肝、肺经。本品辛甘苦三性俱备，辛散轻清凉泄，甘凉益阴，苦寒泄热，既善解外感风热之邪，又善消内伤头目风热，尤其是肝阳上升，肝风内动所致头晕目眩等症。其平肝熄风之效卓著，《药性论》云：“治热头风旋倒地，脑骨疼痛，身上诸风。”但因其品种有别，作用略有不同：白菊花用于平肝明目，杭菊花善于疏散风热，以杭州产者为佳。

（2）钩藤：

甘、微寒，归肝、心包经。肝与心包同为手足厥阴之经，本品专入厥阴，以其甘而微寒，既清热平肝，又熄风定痉，且长于熄风止痉，王旭高列为平肝药类，毕竟本品气味俱薄，不宜单独入药，入煎剂宜另包后下为佳。

（3）天麻：

甘、辛、平，归肝经。“内动之风非天麻不能疗”，其祛风实为上品，以其善入肝，既定内动之风阳，又疏外感之风痰，内伤外感，虚实

诸风，皆为要药。同散药配伍，则治外风，同补药配伍则治虚风，味虽辛甘，辛而不散，甘而不滋，其药力尚单薄，可配伍应用。

（4）代赭石：

苦、甘、寒，归肝、心经。本品色赤，易入血分，苦寒而质重，寒能泻热，重能镇逆。平肝气之上逆，降内动之肝阳，尤有卓效。临床用于眩晕、耳鸣、噎气、呃逆等症。张锡纯说：“赭石色赤，性微凉。能生血兼能凉血，而其质重坠，又善镇逆气，降痰涎，止呕吐，通燥结，用之得当，能建奇效……且性甚和平，虽降逆气而不伤正气，通燥结而毫无开破（宜生服）。 ”（《医学衷中参西录》）但证属虚寒者，不宜服用。

（5）石决明：

咸、寒，归肝经。本品专入肝经，咸能软能泻，质重能镇能潜，具有镇肝清热，滋阴潜阳的效能。其所异者，较之一般潜镇之品不同，尤有补肝阴之长，是以镇中带补，用于阴虚阳亢者尤宜。

（6）珍珠母：

咸、寒，归肝、心包经。本品系珍珠母的贝壳入药，主要用在平肝潜阳，如头眩、耳鸣，以及心肝火旺的神志病证；因其既无益阴之功，又乏解毒之力，远不及珍珠粉之力专而宏，但珍珠粉昂贵，故临床常以本品与养阴或泻火之品配伍，代替珍珠粉。

（7）磁石：

咸、寒，归肝、心、肾经。磁石质重咸寒，在镇潜之中，有摄纳肾气之功，张山雷云：“磁石质重，而具有吸引之性，能入肝肾血分，收

摄上浮之火焰”。因此其镇潜不同于石决明、珍珠母、牡蛎等潜镇之品。妙在有补肾之力，故与补阴药同用，可用于肾气虚弱的气喘。

（8）牡蛎：

咸、微寒，归肝、胆、肾经。生用潜镇，煅用固涩，肝病临床多用生牡蛎，以其平肝潜阳。张山雷云：“牡蛎咸寒，虽介属坚甲，而多粉质，入煎剂自有力量，迥非石决明、蚌壳等之坚硬、无气无味者可比。”此外，临床家有用于怒惊恚气伤及肝胆者，如柴胡龙牡汤，桂枝加龙牡汤等，其镇惊之作用较强；也有的用治温症，《神农本草经》谓其治温症；因其咸能软坚，配贝母可治鼠痿、瘰癧。

（9）玳瑁：

甘、寒，归肝、心经。气味甘寒，有清热解毒之力，质坚体重，又有清心平肝之功。清热解毒之中又长于固摄真阴，非一般清热解毒之品可比，又非一般滋阴之品所能，是以清中有补，补中能清，清补兼施，具涵养之力。张山雷说：“玳瑁亦介类，其色深青而紫，故直入肝肾，滋阴益血……凡真阴不摄，虚火升腾，变生诸幻者，以之吸引于下，涵阴潜阳，最为必要之品。”秦伯未谓：“治血虚头晕，效果良好”。可见其清补兼能之功。

（10）羚羊角：

咸、寒，归肝经，兼入心、肺两经。本品咸寒，入肝经血分，既善清肝热，平热极之风，又善散血解毒，凉血中之斑疹。凉无寒遏之弊，透有转气之功，清中有透，能里能表。《本草纲目》说：“肝主木，开窍于目，其发病也目暗障翳，而羚羊角能平之；肝主风，在合为筋，其发病也小孩惊痫，妇人子痫，大人中风抽搐及筋脉挛急，历节掣痛，而羚羊角能舒之；魂者肝之神也，发病则惊骇不宁，狂越僻谬，而羚羊角能安之；血者肝主藏也，发病则瘀滞下注，疔痛毒痢，痈肿痿痹，产后血气，而羚羊能散之；相火寄于肝胆，在气为怒，病则烦闷气逆，噎塞不

通，寒热及伤寒伏热，而羚羊角能降之。”可见羚羊角用途之广，总其而言，是清肝经血分邪热以定风。

（11）龟板：

咸、甘、平，归肾、肝经。本品咸甘而平，咸入肾，甘缓筋，滋阴益肾，潜阳熄风是其所长，尤宜于阴虚生风的肝风证。张山雷说：“龟板滋阴潜阳……且富有脂膏，力能滋镇，以助培植，则木根既固，庶无拨动之虞，尤为善后必需之品，视金石镇队专治其标者”，胶名“龟板胶”，其力尤胜。

（12）鳖甲：

咸、平，入肝经。咸走血而能软坚，性偏凉而能泄热，气味皆清，滋阴涵阳尤佳。潜阳以摄纳为上，软坚又有入络之功，去恶生新，可用治阴虚风动及疟母等症。

（13）全蝎：

辛、甘、平，归肝经。因蝎善窜，尤易入肝搜风，活络止痛，舒筋止痉。临床多用治一切急慢惊风，偏正头风，中风偏瘫，破伤风等症，入药多用蝎尾，与蜈蚣配伍有相得益彰之妙。

（14）蜈蚣：

咸温、有毒，归肝经。咸温入络，性灵走窜，内而脏腑，外而经络，能开气血之凝聚，善消一切疮疡诸毒，可熄内动之肝风，其搜逐之力尤强。与全蝎功效相近，但力更峻猛。总之，抑肝、镇肝、平肝，以介类潜阳第一，以金石矿类重镇为妥，但切忌叠床架屋，堆药成方。

（三）清热药队

凡遵照“热者寒之”的原则，具有苦寒甘寒之性，能清解肝热，清泻肝火的药物，统称清肝药，宜于肝热、肝火实证。

（1）丹皮：

苦、辛、寒，归心、肝经。《本草纲目》云：“丹皮，和血、生血、凉血，治血中伏火，除烦热。”肝藏血，心主血，本品苦辛寒，入心肝血分，既清血热，又散血止血，清中有散，行中有生，是清肝凉血之妙品。

（2）黄芩：

苦、寒，归肺、胆、胃、大肠经。苦寒本为直折之品，唯黄芩则以清宣为上，凡气郁作热，皆可用之，尤以肝胆郁热，用之更佳。以其善入肝胆，故清肝胆之热是其所长。且随不同配伍而产生不同功用，如配柴胡解气分热结，配芍药清血分伏热，清宣而不凉遏。

（3）龙胆草：

苦、寒，归肝、胆、胃经。大苦大寒，性善沉降，泻肝胆实火，清下焦湿热，多用于肝火证及肝胆湿热黄疸，若肝阴不足者忌用。

（4）山栀子：

苦、寒，归心、肝、肺、胃、三焦经。苦寒泄热，清中有降，性缓而行，多经可入，尤以清三焦浮越之火，除胸膈懊侬之烦热，以及肝火肝热，为其所长。本品配豆豉以轻宣胸膈烦热，配黄芩退气分热，配

丹皮清血分热，配菊花、甘草清肝明目，配茵陈、黄柏能利胆退黄，配大黄能消瘀泄热，其清热作用以轻宣为上。

（5）青黛：

咸、寒，归肝经。青黛专入肝经，其味咸能软，能直入血分，非苦寒直折可比，有养阴退热之功，具有凉血解毒之力。秦伯未说：“胆热六郁，舌绛唇红，用一切养阴清热不除者，用青黛最佳”。肝脉弦而有湿，青黛亦为对症之剂；肝火冲逆吐衄之症，每多用之。

（6）夏枯草：

苦、辛、寒，归肝、胆经。《滇南本草》谓本品“行肝气、开肝郁……散瘰癧，周身结核”。辛能散能行，解肝之气机郁结；苦能清能降，泄肝胆郁之火，临床多用于头目眩晕，性情急躁，失眠多梦，以及颈项瘰癧等证。散结可配玄参、贝母；清肝可配菊花、山梔子；肝阳上亢，可配石决明、草决明。

（7）牛黄：

苦、平，有小毒，归肝、心经。《本经》云：“主惊痫寒热，热盛狂痉。”惊痫多缘于心肝热盛，因本品气味芳香，能清心豁痰开窍，因其入肝，对肝热生风，风火相搏之证，能起到凉肝泄热之效。凡肝心热炽神昏，为散分吞，其效尤佳。

（8）芦荟：

苦、寒，入肝、心包经。苦寒泄热，平泻肝火，较龙胆草尤峻，且有通便之功，肝热神昏腑实，用之尤宜。

（9）青蒿：

苦、辛、寒，归肝胆经。苦寒气香，香能悦脾，苦能泄热，善清肝胆血分之热，又不犯冲和之气，启阴分伏热而外透，止疟退骨蒸又有奇功。肝病阴分伏热用之尤宜。

（10）茵陈：

微苦，微寒，归肝、胆、肾、脾经。微苦微寒，透肝胆郁热，宣脾胃湿滞，治黄疸有奇功。临床运用每多配伍他药，湿热郁滞者，用量可略重。

近年来，我国广大医务人员，发掘了不少有较好疗效的清肝泄热解毒中草药，如虎杖、垂盆草、板蓝根、贯众、大青叶等，已被广泛用于治疗肝胆疾病，限于篇幅，这里从略。

（四）疏肝理气药队

凡遵照“木郁达之”和“疏气令调”的原则，具有辛散香窜等性味，以达疏肝理气作用的药物，叫疏肝理气药。临床用治肝气郁结，症见：胸胁胀满疼痛，或巅顶及两侧额胀痛，少腹、睾丸均胀痛等症，因理气药大都香燥耗散，能损伤阴血，临床宜与他药配伍应用，中病即止。

（1）柴胡：

微苦、微辛、微寒，入肝、胆、心包经。柴胡虽具有辛散作用，但非单纯解表剂，《本草从新》云：“柴胡宣畅气血，散结调经”，“人第知柴胡能发表，而不知柴胡最能和里”。柴胡贵在和里，是因为辛能散，苦能降，解肝气之郁结尤佳，如配伍黄芩和解表里，配升麻升阳举陷，配枳壳升降清浊，配黄连清散郁火，配白芍疏肝止痛，配香附疏肝解郁，配白术调和肝脾，配郁金、丹参疏肝化瘀，凡此等等，说明柴胡能表能里，能上能下，能散能收，只要配伍得当，用之自无流弊。但因其气味俱薄，偏于升散，对肝肾阴虚，或气火上逆的患者用之宜慎。

（2）青皮：

苦、辛、温，入肝胆经。青陈皮皆能理气，但作用有别，陈皮理脾肺之气尤佳，青皮则长于疏肝理气止痛，药性峻烈，沉降下走，走而不守，病在肝胆气分尤宜。若肝脾同病或肝胃不和者，与陈皮同施。

（3）香附：

辛、微甘、苦，入肝、三焦、胃经。前人谓香附为“气病之总司，妇科之主帅”，虽然比喻偏激，但却说明本品为疏肝理气要药。从性味而论，一物而兼辛散、甘缓、苦降之能，又无偏寒偏热之弊，疏肝之中

又利三焦，理气之中兼和血分，因其香窜耗气，入药多用醋、酒、盐、姜汁、童便等分别予以制炒，既制其香窜之性，又增其不同的功效。

（4）川楝子：

即金铃子，苦寒有小毒。历代医家对本品归经及作用有不同说法，或谓入心及小肠经，或谓入肝、脾、胃经，或谓入诸经。《本草分经审治》云其“泻肝火”，《中国医学大辞典》云其“泄肝邪，治肝气痛、肝气胀，为泻肝泄热良品，肝经腹痛及疝痛要药”。临床多用以治疗气郁化火，肝气横逆所致脘腹胁痛，或小肠疝痛以及湿热下注所引起的睾丸肿痛，可见以本品主要作用而论，不应列为杀虫剂。

（5）香橼：

辛、微苦、酸、温，入肝、脾、胃经。性微苦，味酸温，入肝以理气舒肝，入脾胃以导滞理脾，既疏肝理气，又顺气化痰，虽气清香，却无劫燥之弊，对肝胃不和属气滞者尤有卓效。

（6）佛手：

辛、苦、温，入肝、脾、肺经。佛手功同香橼，清香之气尤胜，疏肝理气，理脾开胃。临床多用于肝胃气滞，脘腹胀痛，噯气呕吐等症。

（7）玫瑰花：

甘、微苦、温，入肝、脾经。味甘微苦入肝以柔养肝木，气芳香入脾以醒运脾湿，理气柔肝之中又能活血，是以气血同治，理脾柔肝之通用剂，临床用于肝胃气痛，胁部闷胀，妇女月经不调，损伤瘀痛诸证，皆有良效。

（8）路路通：

苦、微涩，入肝、胃经。味苦而具通利之性，微涩而有活血通络之能，既可用于肝络不和之证，常配伍旋覆花汤，又有利水消肿之能，如浮肿等症，是肝病活络常用之品。

（9）橘叶、橘核：

橘叶苦平，橘核辛苦温。二药皆专入肝经，以疏肝理气为其所长。但不同的是：橘叶疏通肝络，治胁痛及妇女乳房胀痛尤佳；橘核长于散结止痛，多用于男子睾丸肿痛，小肠疝气等症。

（五）温肝药队

凡遵“寒者温之”的原则，气味甘温，具有温中散寒作用，用以治疗肝寒实证的药物，叫做温肝药。凡症见：面色青白，肢冷而麻，畏寒，甚则呕酸上气，痉挛拘急，或剧烈疼痛等证，皆可用之。

（1）桂枝：

辛、甘、温，入心、肺、膀胱经。桂枝功能甚广，非单纯解表药，《本草疏证》云：“和营、通阳、利水、下气、行瘀、补中，为桂枝六大功效”。仲景善用桂枝，亦非单纯解表，如治短气之苓桂术甘汤取其升，治奔豚之桂枝加桂汤取其降，治外感咳喘之大、小青龙汤取其散，究之其温降之作用尤为其长，其所以降逆是因其具有平肝、理肝、养肝作用之故，张锡纯说：“桂枝善抑肝木之盛使不横恣，又善理肝木之郁使之条达也。”（《医学衷中参西录》）王旭高列肉桂以补肝阳，实不如桂枝温肝之力专。

（2）沉香：

辛、苦、温，归经多认为入脾、胃、肾经，很少谈到入肝经。以其辛温，能温能散能降能纳。温肝是以温中散寒为长，纳肾是以收敛肾气为用，临床多用于七情怫郁，气逆气厥等症，若配伍得当，其作用与用途更广。《本草求真》谓：“同丁香、肉桂治胃虚呃逆，同紫苏、豆蔻治胃冷呕吐，同茯苓、人参治心神不足，同川椒、肉桂治命门火衰，同苁蓉、麻仁治大肠虚秘。”可见本品温肝之作用实不为次。

（3）肉桂：

辛、甘、大热，入肾、肝、命门经。辛甘大热，温通血脉，温肝之用强。《本草求真》云：“气血不和，肉桂治血脉不通，有鼓舞血气之能。”临床中常配伍应用。如配当归、干姜、熟地等，方名理阴煎，治虚寒痛经；配八珍等汤，方名十全大补，治气血两虚；以本品为引，组成阳和汤，治寒性疮疡；若反配知母、黄柏，方名滋肾丸，治下焦湿热。其回阳救逆之功不及附子；温肝散寒，和血通脉之功不及桂枝。因其辛温大热，阴虚阳亢及孕妇均当忌用。

（4）小茴香：

辛、温，入肝、肾、脾、胃经。以其辛温散寒，芳香疏肝理气，既暖肾又长于止痛，临床多用以治疗肝病寒凝气滞疝气等证。暖肝煎、香橘散即是。

（5）吴茱萸：

辛、苦、热，有小毒，入肝、脾、肾、胃经。味辛苦，辛散苦降之能并长，性热燥烈，又专于温中止痛，降逆止呕。其作用机制：①散厥阴寒邪，如头痛，干呕，吐涎沫之吴茱萸汤证；②温降胃中之浊气，调和肝胃而止呕吐酸水，如左金丸证；③舒筋脉寒湿之邪，如寒湿脚气之鸡鸣散证。总之，辛开苦降之中善于降，善下行也。

（6）艾叶：

辛、苦、温，入肝、脾、肾经。苦燥而辛散，芳香而温通，专入三阴经，肝病用艾叶，主要取其温通气血，暖经脉，通寒湿，多侧重于妇科，如调经、治崩及产后出血等。

（7）荔枝核：

辛、温，入肝、胃经。本品取其辛温之性，疏肝胃之气滞，散血脉中之寒湿，对肝经血分寒湿气滞所致疝痛，睾丸肿痛，男女脘腹胀痛及妇女少腹刺痛等，皆有效验，《本草备要》云：“入肝肾，散滞气，避寒邪，治胃脘痛及妇人血气痛。”

（六）和肝药队

“和”即调和。和肝是指调和肝脏气血而言，它不同于苦辛并用，调和肝脾。凡是具有调和肝脏气血作用的药物，都属和肝药类。秦伯未说：“和肝药包括活血……进一步即是行血祛瘀。”

（1）川芎：

辛、温，入肝、胆、心包经。以其辛温香窜，走而不守，故为血中之气药。即是说行血中之气滞，能上行巅顶，下达血海，外彻皮毛，旁通四肢，既活血行气，又开郁止痛。气滞血瘀，多配伍柴胡、郁金、香附；血虚当补，需佐本品以温通，使补而不滞。因其辛窜，凡血虚、血燥、肝火、肝阳等症，皆宜慎用。

（2）赤芍：

苦、微寒，入肝经。因其味苦微寒，善入肝经血分，故活血之中兼有凉血散瘀之能，活血之力较丹皮为大，凉血之力不及丹皮，若肝火旺而目赤肿痛者，每多用之，以其泻肝火故也。《药品凡义》云其“泻肝火”，但需佐入菊花、薄荷以轻宣。

（3）丹参：

苦、微寒，入心、肝经。俗语云：“一味丹参饮，功胜四物汤”。本品非以补血为长，却以活血为专，以通为补。因其苦能降泄，微寒清热，专入心肝血分。入肝养血活血，祛瘀生新，入心“补心安志，安神宁心”（《滇南本草》）。临床多用于癥瘕、经闭、心腹刺痛等症，以其软缩肝脾尤优。

（4）郁金：

辛、苦、寒，入心、肝、胆经。因其苦寒能清能降，辛苦两兼，能开能降，其芳香宣达之性，善入气分以清气行气，故既理气分之郁结，又善解血分之瘀热。《本草备要》云：“行气、解郁、泄血、破瘀，凉心热，散肝邪。临床多用于肝病气滞，胸胁胀满疼痛，或癥瘕初期。因产地不同，有川、广之分，作用大致雷同。”

（5）玄胡索：

辛、苦、温，入肝兼入脾经、心经。系气血双调之品，既行血中之气，又行血中之血，以温通为主。临床多用于肝病胁痛、腕痛等症，其他属气滞血瘀疼痛，悉可用之，其镇痛作用明显。

（6）桃仁：

苦平、微甘，入肝经，兼入心、肺、大肠、脾经。本品含脂质润，苦甘微平，善入肝经血分，兼能润燥，既破瘀行血，又养血润肠，随其配伍不同，而作用甚广。如配理气药，治胸胁络痛；配滋阴润燥药治阴亏津枯便秘；配大黄、山甲、红花等治瘀血肿痛；配芦根、冬瓜仁、薏苡仁等治肠痛、肺痛。肝病多用以活血化瘀，量大则化瘀，量小则活血，一般不宜大量使用。

（7）红花：

辛、温，入肝经，兼入心经。其性辛温，能散能通，多用以通经止痛、消癥。肝病脉络不通而瘀滞，表现胁痛、癥瘕等症，皆可用之。因产地不同，作用有别。藏红花性偏甘寒，与草红花有类似作用，且更有凉血解毒之功，用量宜酌，“多用破留血，少用养血”（《本草衍义补遗》）。

（8）三棱：

苦平，入肝、脾经。三棱的作用主要在于苦平泄降，活血祛瘀，行气止痛。对其药用作用尚有不同看法，一种认为本品力峻，以致后来视为慎用之品，《本草纲目》云：“其功可近于香附而力峻，故难以服。”另一种认为本品大能和气血，为常用之品，张锡纯说：“若与参、术、芪诸药并用，大能开胃进食，调血和血。”并谓其“治女子瘀血，虽坚如铁石，亦能徐徐消除，而猛烈开破之品不能建此奇功，此三棱、莪术独具之良能也，而耳食者流，恒以其能消坚开瘀，转疑为猛烈之品而不敢轻用，几何不埋没良药哉”。临床诊治肝病，本品配莪术善消肝脾肿大。

（9）莪术：

苦、辛、温，入肝、脾经。苦泄温通，善行气破血，化积消癥。临床上常与三棱同时配伍，两者比较，活血之力三棱优于莪术，理气之能莪术优于三棱。临床多用治肝病瘀血积久坚硬，或肝脾肿大。

（10）田三七：

甘、微苦、温，入肝、胃经。其功用长于止血化瘀，消肿止痛，止血而不留瘀，化瘀而不伤正。用黄酒送下止痛之效速，配活血行气之品，消肿之能尤显。无怪前人有谓：“一味三七，可代《金匱》之下瘀血汤，而较用下瘀血汤尤为稳妥。”可谓经验之谈。

（11）泽兰：

苦、辛、微温，入肝、脾经。味苦辛而气香，善入脾而理滞，《本草经疏》云：“主大腹水肿，身面四肢浮肿，骨节中水气。”性温通达，善入肝有治血行瘀消肿之功，《本草求真》云：“入脾行水，入肝活血。临床多用于治疗妇人经闭，通经散结而不伤正。肝病气血郁滞，脾

不健运，水湿不化者，效果较好。

（12）月季花：

甘、微温，入肝经。本品长于行气滞，畅血运，止疼痛，是气血双理之品。肝病中用于肝郁气滞，经脉瘀阻诸证。妇人月经不调，或经期拘挛性腹痛等证，临床皆可用之。

综上所述，我们在前人有关肝病用药归类的基础上，综合诸家之长以及我们的临床实践，对肝病用药作了初步归纳和整理，共分为补、抑、清、疏、温、和六类。每一类药队中，对常用药物作了扼要的阐述，但因每一药队之间，可根据不同病证的内在联系，互相配伍成方，而每一类药物中，也还有一些药物未作归纳阐述，这就说明我们还必须了解每一药性之间的主治功能，并进而了解其多方面作用，临床上才能运用自如。

Table of Contents

[伤寒论通俗讲话](#)

[封面](#)

[内封](#)

[版权页](#)

[刘渡舟医书七种编写委员会](#)

[出版说明](#)

[第一辑 收录13种名著](#)

[第二辑 收录14种名著](#)

[第三辑 收录20种名著](#)

[第四辑 收录6种名著](#)

[第五辑 收录19种名著](#)

[第六辑 收录11种名著](#)

[第七辑 收录15种名著](#)

[第八辑 收录11种名著](#)

[第九辑 收录11种名著](#)

[第十辑 收录7种名著（刘渡舟医书七种）](#)

[整理说明](#)

[一、概论](#)

[（一）《伤寒论》的产生与演变](#)

[（二）《伤寒论》是一部什么书](#)

[（三）什么是“六经”](#)

[1.六经与脏腑经络的关系](#)

[2.六经与六气的关系](#)

[（四）六经病的传变](#)

[（五）六经病的主证、兼证、变证与挟杂证](#)

[（六）《伤寒论》的治法与方剂](#)

[（七）《伤寒论》的辨证论治精神](#)

[（八）怎样学习《伤寒论》](#)

[1.首先要熟读原文，在熟悉原文的基础上重点掌握方证](#)

[2.要学好《伤寒论》，还必须要有较好的古汉语基础](#)

[3.熟悉并掌握中医药基本](#)

理论，是学好《伤寒论》的一个前提

4.与临床实践相结合，是学习《伤寒论》的最基本方法，也是学好《伤寒论》的关键所在

5.最后要指出的是，学习《伤寒论》一定要注意上下、前后条文之间的联系

二、辨病发阴阳寒热纲要

三、辨太阳病脉证并治

（一）太阳病辨证纲要

（二）太阳病经证

1.太阳中风证治

2.太阳伤寒证治

3.辨麻桂越婢合方的小汗证

（三）辨不可发汗证

（四）辨传经与不传经

（五）辨太阳腑证并治

1.太阳蓄水证治

2.太阳蓄血证治

（六）虚烦证治与治疗禁忌

1.栀子豉汤证

2.栀子豉汤加减证

3.栀子豉汤禁忌证

（七）结胸证治

1.大陷胸丸证

2.大陷胸汤证

3.小陷胸汤证

4.三物白散证

5.陷胸汤的禁忌与结胸证预后

（八）心下痞证治

1.半夏泻心汤证

2.生姜泻心汤证

3.甘草泻心汤证

4.大黄黄连泻心汤证

5.附子泻心汤证

6.旋覆代赭汤证

(九) 辨太阳病变证治法

1.表里先后、标本缓急与调整阴阳的治疗法则

2.邪热迫肺作喘证治

3.协热下利证治

4.误治变虚证治

5.火逆的变证

(十) 太阳病类证与治疗

1.温病

2.风温

3.风寒湿痹证

四、辨阳明病脉证并治

(一) 阳明病辨证纲要

(二) 阳明病成因

(三) 辨阳明病腑证并治

1.调胃承气汤证

2.小承气汤证

3.大承气汤证

4.麻子仁丸证

5.蜜煎导法

(四) 辨阳明病可下与不可下

(五) 辨阳明病经证并治

(六) 辨阳明病热证并治

(七) 辨阳明病寒证并治

(八) 辨阳明病蓄血证并治

(九) 湿热发黄证治

(十) 阳明病的预后

五、辨少阳病脉证并治

(一) 少阳病辨证纲要

(二) 少阳病的正治法

(三) 少阳病治疗禁忌

(四) 少阳病机进退

(五) 少阳病权变治法

1.柴胡桂枝汤证

- [2.大柴胡汤证](#)
- [3.柴胡加芒硝汤证](#)
- [4.柴胡桂枝干姜汤证](#)
- [5.柴胡加龙骨牡蛎汤证](#)

[\(六\) 热入血室证治](#)

[六、合病、并病](#)

- [\(一\) 太阳阳明合病](#)
- [\(二\) 太阳少阳合病](#)
- [\(三\) 阳明少阳合病](#)
- [\(四\) 三阳合病](#)
- [\(五\) 太阳阳明并病](#)
- [\(六\) 太阳少阳并病](#)
- [\(七\) 少阳阳明并病](#)

[七、辨太阴病脉证并治](#)

- [\(一\) 太阴病辨证纲要](#)
- [\(二\) 太阴脏病证治](#)
- [\(三\) 太阴经病证治](#)
- [\(四\) 太阴经脏俱病证治](#)

[八、辨少阴病脉证并治](#)

- [\(一\) 少阴病辨证纲要](#)
- [\(二\) 少阴病寒证](#)

- [1.麻黄附子细辛汤证与麻黄附子甘草汤证](#)
- [2.附子汤证](#)
- [3.真武汤证](#)
- [4.四逆汤证](#)
- [5.通脉四逆汤证](#)
- [6.白通汤与白通加猪胆汁汤证](#)
- [7.吴茱萸汤证](#)
- [8.桃花汤证](#)

[\(三\) 少阴病热证](#)

- [1.黄连阿胶汤证](#)
- [2.猪苓汤证](#)
- [3.少阴邪热外转太阳证](#)
- [4.四逆散证](#)

[\(四\) 少阴咽痛证治](#)

[\(五\) 少阴病急下证](#)

[\(六\) 少阴病治疗禁忌](#)

[\(七\) 少阴病的预后](#)

[九、辨厥阴病脉证并治](#)

[\(一\) 厥阴病辨证纲要](#)

[\(二\) 厥阴病寒热错杂证治](#)

[1.乌梅丸证](#)

[2.干姜黄芩黄连人参汤证](#)

[3.麻黄升麻汤证](#)

[\(三\) 厥阴病寒证](#)

[1.吴茱萸汤证](#)

[2.当归四逆汤证](#)

[\(四\) 厥阴病热证](#)

[\(五\) 厥阴病的病机进退](#)

[\(六\) 厥阴病治疗禁忌](#)

[\(七\) 厥阴病预后](#)

[十、辨霍乱病脉证并治](#)

[\(一\) 霍乱病辨证纲要](#)

[\(二\) 霍乱与伤寒的鉴别](#)

[\(三\) 霍乱病的证治](#)

[1.霍乱表里寒热证治](#)

[2.霍乱吐利亡阳证治](#)

[3.霍乱吐利阴阳两虚证治](#)

[4.霍乱吐利阳亡阴竭证治](#)

[5.霍乱病后的调治](#)

[十一、辨阴阳易差后劳复病脉证并治](#)

[\(一\) 阴阳易证治](#)

[\(二\) 差后劳复证治](#)

[\(三\) 差后复发热证治](#)

[\(四\) 差后腰以下有水气证治](#)

[\(五\) 差后喜唾证治](#)

[\(六\) 差后虚羸少气欲吐证治](#)

[\(七\) 差后日暮微烦证治](#)

[伤寒论十四讲](#)

[封面](#)

[内封](#)

[版权页](#)

[刘渡舟医书七种编写委员会](#)

[出版说明](#)

[整理说明](#)

[再版序](#)

[前言](#)

[目录](#)

[第一讲 《伤寒论》导言](#)

[一、《伤寒论》的历史变革](#)

[二、《伤寒论》是一部什么书](#)

[三、六经的概念](#)

[四、六经辨证方法](#)

[五、六经为病传变](#)

[六、“六经”析疑](#)

[七、论八纲辨证与六经辨证的关系](#)

[八、《伤寒论》的治疗法则](#)

[九、《伤寒论》的方剂](#)

[十、学习《伤寒论》的方法](#)

[第二讲 试论《伤寒论》条文组织排列的意义](#)

[一、《太阳病上篇》30条](#)

[二、《太阳病中篇》97条](#)

[三、《太阳病下篇》51条](#)

[四、《阳明病篇》84条](#)

[五、《少阳病篇》10条](#)

[六、《太阴病篇》8条](#)

[七、《少阴病篇》45条](#)

[八、《厥阴病篇》58条](#)

[九、《霍乱病篇》10条](#)

[十、《阴阳易瘥后劳复病篇》7条](#)

[十一、小结](#)

[第三讲 试论六经为病提纲证的意义](#)

[一、太阳病的提纲证](#)

[二、阳明病的提纲证](#)

[三、少阳病的提纲证](#)

[四、太阴病的提纲证](#)

[五、少阴病的提纲证](#)

[六、厥阴病的提纲证](#)

[第四讲 《伤寒论》的气化学说](#)

- [一、太阳经病](#)
- [二、阳明经病](#)
- [三、少阳经病](#)
- [四、太阴经病](#)
- [五、少阴经病](#)
- [六、厥阴经病](#)
- [七、小结](#)

[第五讲 试论桂枝汤的加减证治](#)

- [一、桂枝汤的适应证](#)
- [二、桂枝汤的临床应用](#)
- [三、桂枝汤的加减应用](#)

[第六讲 试论麻黄汤的加减证治](#)

- [一、麻黄汤的适应证](#)
- [二、麻黄汤的临床应用](#)
- [三、麻黄汤的加减应用](#)

[第七讲 试论苓桂剂的加减证治](#)

- [一、水气的概念](#)
- [二、水气上冲的证机](#)
- [三、水气上冲的证治](#)

[第八讲 试论白虎汤类的加减证治](#)

- [一、白虎汤](#)
- [二、白虎加人参汤](#)
- [三、白虎加桂枝汤](#)
- [四、竹叶石膏汤](#)
- [五、白虎加苍术汤*](#)
- [六、玉女煎*](#)
- [七、化斑汤*](#)

[第九讲 试论承气汤类的加减证治](#)

- [一、大承气汤](#)
- [二、小承气汤](#)
- [三、调胃承气汤](#)
- [四、麻子仁丸](#)
- [五、桃核承气汤](#)
- [六、厚朴七物汤](#)
- [七、厚朴三物汤](#)
- [八、厚朴大黄汤](#)
- [九、大黄硝石汤](#)

[十、大黄牡丹皮汤](#)

[十一、三一承气汤*](#)

[十二、黄龙汤*](#)

[十三、增液承气汤*](#)

[第十讲 试论柴胡汤类的加减证治](#)

[一、小柴胡汤证治](#)

[二、小柴胡汤的加减证治](#)

[第十一讲 试论理中汤类的加减证治](#)

[一、理中汤](#)

[二、桂枝人参汤](#)

[三、甘草干姜汤](#)

[第十二讲 试论四逆汤类的加减证治](#)

[一、四逆汤](#)

[二、四逆加人参汤](#)

[三、通脉四逆汤](#)

[四、通脉四逆加猪胆汁汤](#)

[五、白通汤](#)

[六、白通加猪胆汁汤](#)

[七、干姜附子汤](#)

[八、茯苓四逆汤](#)

[九、附子汤](#)

[第十三讲 对寒热错杂诸方综述](#)

[一、半夏泻心汤](#)

[二、附子泻心汤](#)

[三、黄连汤](#)

[四、乌梅丸](#)

[五、麻黄升麻汤](#)

[六、干姜黄芩黄连人参汤](#)

[第十四讲 使用经方的关键在于抓住主证](#)

[一、什么是主证，为什么要先抓主证](#)

[二、抓主证，也要注意兼证](#)

[三、变证的形成及其临床意义](#)

[四、夹杂证形成的特点](#)

[五、抓主证，使用经方的治例](#)

[六、小结](#)

[伤寒论论解](#)

[封面](#)

[内封](#)
[版权页](#)
[刘渡舟医书七种编写委员会](#)
[出版说明](#)
[整理说明](#)
[前言](#)
[凡例](#)
[目录](#)
[伤寒卒病论集](#)
[绪论](#)

[一、《伤寒论》的产生与演变](#)
[二、《伤寒论》是一部什么书](#)
[三、什么是六经](#)
[四、六经病的传变](#)
[五、六经病的主证、兼证、变证与夹杂证](#)
[六、《伤寒论》的治法与方剂](#)
[七、《伤寒论》的辨证论治精神](#)

[各论](#)

[辨太阳病脉证并治法上](#)
[辨太阳病脉证并治法中](#)
[辨太阳病脉证并治法下](#)
[辨阳明病脉证并治法](#)
[辨少阳病脉证并治法](#)
[辨太阴病脉证并治法](#)
[辨少阴病脉证并治法](#)
[辨厥阴病脉证并治法](#)
[辨霍乱病脉证并治法](#)
[辨阴阳易差后劳复病脉证并治法](#)

[附：《伤寒论》原文校勘](#)

[【伤寒论原文校勘说明】](#)

[【蓝本及对校书目版本、出版年代】](#)

[新编伤寒论类方](#)

[封面](#)
[内封](#)
[版权页](#)
[刘渡舟医书七种编写委员会](#)
[出版说明](#)

[整理说明](#)

[前言](#)

[Table of Contents](#)

[桂枝汤类概述](#)

[一、桂枝汤](#)

[二、桂枝加葛根汤](#)

[三、桂枝加附子汤](#)

[四、桂枝去芍药汤](#)

[五、桂枝去芍药加附子汤](#)

[六、桂枝麻黄各半汤](#)

[七、桂枝二麻黄一汤](#)

[八、桂枝二越婢一汤](#)

[九、桂枝去桂加茯苓白术汤](#)

[十、桂枝加厚朴杏子汤](#)

[十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤](#)

[十二、桂枝甘草汤](#)

[十三、小建中汤](#)

[十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤](#)

[十五、桂枝加桂汤](#)

[十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤](#)

[十七、桂枝附子汤](#)

[十八、去桂加白术汤](#)

[十九、桂枝加芍药汤](#)

[二十、桂枝加大黄汤](#)

[二十一、桂枝人参汤](#)

[麻黄汤类概述](#)

[一、麻黄汤](#)

[二、大青龙汤](#)

[三、小青龙汤](#)

[四、麻黄杏仁甘草石膏汤](#)

[五、麻黄连翘赤小豆汤](#)

[六、麻黄细辛附子汤](#)

[七、麻黄附子甘草汤](#)

[八、麻黄升麻汤](#)

[葛根汤类概述](#)

[一、葛根汤](#)

- [二、葛根加半夏汤](#)
- [三、葛根黄芩黄连汤](#)

[抵当汤类概述](#)

- [一、桃核承气汤](#)
- [二、抵当汤](#)
- [三、抵当丸](#)

[栀子豉汤类概述](#)

- [一、栀子豉汤](#)
- [二、栀子甘草豉汤](#)
- [三、栀子生姜豉汤](#)
- [四、栀子厚朴汤](#)
- [五、栀子干姜汤](#)
- [六、枳实栀子豉汤](#)
- [七、栀子柏皮汤](#)

[陷胸汤类概述](#)

- [一、大陷胸丸](#)
- [二、大陷胸汤](#)
- [三、十枣汤](#)
- [四、小陷胸汤](#)
- [五、白散](#)
- [六、瓜蒂散](#)

[泻心汤类概述](#)

- [一、半夏泻心汤](#)
- [二、大黄黄连泻心汤](#)
- [三、附子泻心汤](#)
- [四、生姜泻心汤](#)
- [五、甘草泻心汤](#)
- [六、旋覆代赭汤](#)

[甘草汤类概述](#)

- [一、甘草汤](#)
- [二、炙甘草汤](#)
- [三、甘草附子汤](#)
- [四、甘草干姜汤](#)

[苓桂术甘汤类概述](#)

- [一、茯苓桂枝白术甘草汤](#)
- [二、茯苓桂枝甘草大枣汤](#)
- [三、茯苓甘草汤（苓桂姜甘汤）](#)

[四、五苓散](#)

[五、猪苓汤](#)

[六、文蛤散](#)

[黄芩黄连汤类概述](#)

[一、黄芩汤](#)

[二、黄芩加半夏生姜汤](#)

[三、黄连汤](#)

[四、黄连阿胶汤](#)

[白虎汤类概述](#)

[一、白虎汤](#)

[二、白虎加人参汤](#)

[三、竹叶石膏汤](#)

[承气汤类概述](#)

[一、调胃承气汤](#)

[二、小承气汤](#)

[三、大承气汤](#)

[四、麻子仁丸](#)

[五、蜜煎导方](#)

[六、猪胆汁灌方](#)

[柴胡汤类概述](#)

[一、小柴胡汤](#)

[二、大柴胡汤](#)

[三、柴胡加芒硝汤](#)

[四、柴胡桂枝汤](#)

[五、柴胡桂枝干姜汤](#)

[六、柴胡加龙骨牡蛎汤](#)

[七、四逆散](#)

[芍药当归汤类概述](#)

[一、芍药甘草汤](#)

[二、芍药甘草附子汤](#)

[三、当归四逆汤](#)

[四、当归四逆加吴茱萸生姜汤](#)

[干姜汤类概述](#)

[一、干姜附子汤](#)

[二、干姜黄芩黄连人参汤](#)

[三、理中丸（汤）](#)

[赤石脂汤类概述](#)

[一、赤石脂禹余粮汤](#)
[二、桃花汤](#)

[四逆汤类概述](#)

[一、四逆汤](#)
[二、四逆加人参汤](#)
[三、茯苓四逆汤](#)
[四、通脉四逆汤](#)
[五、通脉四逆加猪胆汁汤](#)
[六、真武汤](#)
[七、白通汤](#)
[八、白通加猪胆汁汤](#)
[九、附子汤](#)

[杂方类概述](#)

[一、厚朴生姜半夏甘草人参汤](#)
[二、茵陈蒿汤](#)
[三、猪肤汤](#)
[四、桔梗汤](#)
[五、苦酒汤](#)
[六、半夏散及汤](#)
[七、乌梅丸](#)
[八、白头翁汤](#)
[九、吴茱萸汤](#)
[十、烧裯散](#)
[十一、牡蛎泽泻散](#)

[金匱要略詮解](#)

[封面](#)

[内封](#)

[版权页](#)

[刘渡舟医书七种编写委员会](#)

[出版说明](#)

[整理说明](#)

[前言](#)

[金匱要略方论序](#)

[凡例](#)

[目录](#)

[脏腑经络先后病脉证第一](#)

[概说](#)

[结语](#)

[痉湿喝病脉证第二](#)

[概说](#)

[结语](#)

[百合狐惑阴阳毒病证治第三](#)

[概说](#)

[结语](#)

[疟病脉证并治第四](#)

[概说](#)

[结语](#)

[中风历节病脉证并治第五](#)

[概说](#)

[结语](#)

[血痹虚劳病脉证并治第六](#)

[概说](#)

[结语](#)

[肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七](#)

[概说](#)

[结语](#)

[奔豚气病脉证治第八](#)

[概说](#)

[结语](#)

[胸痹心痛短气病脉证治第九](#)

[概说](#)

[结语](#)

[腹满寒疝宿食病脉证治第十](#)

[概说](#)

[结语](#)

[五脏风寒积聚病脉证并治第十一](#)

[概说](#)

[结语](#)

[痰饮咳嗽病脉证并治第十二](#)

[概说](#)

[结语](#)

[消渴小便不利淋病脉证并治第十三](#)

[概说](#)

[结语](#)

[水气病脉证并治第十四](#)

[概说](#)

[结语](#)

[黄疸病脉证并治第十五](#)

[概说](#)

[结语](#)

[惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六](#)

[概说](#)

[结语](#)

[呕吐哕下利病脉证治第十七](#)

[概说](#)

[结语](#)

[疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八](#)

[概说](#)

[结语](#)

[跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九](#)

[概说](#)

[结语](#)

[妇人妊娠病脉证并治第二十](#)

[概说](#)

[结语](#)

[妇人产后病脉证治第二十一](#)

[概说](#)

[结语](#)

[妇人杂病脉证并治第二十二](#)

[概说](#)

[结语](#)

[杂疗方第二十三](#)

[概说](#)

[结语](#)

[禽兽鱼虫禁忌并治第二十四](#)

[概说](#)

[结语](#)

[果实菜谷禁忌并治第二十五](#)

[概说](#)

[结语](#)

[附：《金匱要略方论》原文校勘](#)

[【血痹虚劳病脉证并治第六】](#)
[【惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六】](#)
[【杂疗方第二十三】](#)

[经方临证指南](#)

[封面](#)

[内封](#)

[版权页](#)

[刘渡舟医书七种编写委员会](#)

[出版说明](#)

[整理说明](#)

[刘渡舟简介](#)

[序](#)

[Table of Contents](#)

[上篇 经方临证治验录](#)

- [1. 桂枝汤证](#)
- [2. 桂枝加葛根汤证](#)
- [3. 桂枝加附子汤证](#)
- [4. 桂枝去芍药汤证](#)
- [5. 桂枝去芍药加附子汤证](#)
- [6. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证](#)
- [7. 桂枝加桂汤证](#)
- [8. 桂枝加龙骨牡蛎汤证](#)
- [9. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证](#)
- [10. 桂枝加芍药汤证](#)
- [11. 桂枝加大黄汤证](#)
- [12. 桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤证](#)
- [13. 黄芪桂枝五物汤证](#)
- [14. 麻黄汤证](#)
- [15. 麻黄加术汤证](#)
- [16. 桂枝二麻黄一汤证](#)
- [17. 桂枝二越婢一汤证](#)
- [18. 葛根汤证](#)
- [19. 葛根加半夏汤证](#)
- [20. 小青龙汤证](#)
- [21. 大青龙汤证](#)
- [22. 麻黄杏仁甘草石膏汤证](#)
- [23. 越婢加半夏汤证](#)

- [24. 越婢加术汤证](#)
- [25. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤证](#)
- [26. 茯苓桂枝白术甘草汤证](#)
- [27. 茯苓桂枝甘草大枣汤证](#)
- [28. 茯苓甘草汤证](#)
- [29. 苓桂杏甘汤证](#)
- [30. 五苓散证](#)
- [31. 桂枝去桂加茯苓白术汤证](#)
- [32. 桃核承气汤证](#)
- [33. 抵当汤证](#)
- [34. 栀子豉汤证](#)
- [35. 栀子厚朴汤证](#)
- [36. 大陷胸汤证](#)
- [37. 大陷胸丸证](#)
- [38. 小陷胸汤证](#)
- [39. 大黄黄连泻心汤证](#)
- [40. 附子泻心汤证](#)
- [41. 半夏泻心汤证](#)
- [42. 生姜泻心汤证](#)
- [43. 甘草泻心汤证](#)
- [44. 旋覆代赭汤证](#)
- [45. 黄连汤证](#)
- [46. 黄芩汤证](#)
- [47. 白虎汤证](#)
- [48. 白虎加人参汤证](#)
- [49. 白虎加桂枝汤证](#)
- [50. 白虎加苍术汤证](#)
- [51. 调胃承气汤证](#)
- [52. 小承气汤证](#)
- [53. 大承气汤证](#)
- [54. 麻子仁丸证](#)
- [55. 厚朴七物汤证](#)
- [56. 茵陈蒿汤证](#)
- [57. 麻黄连翘赤小豆汤证](#)
- [58. 栀子柏皮汤证](#)
- [59. 小柴胡汤证](#)
- [60. 大柴胡汤证](#)

[61. 柴胡桂枝汤证](#)
[62. 柴胡桂枝干姜汤证](#)
[63. 柴胡加龙骨牡蛎汤证](#)
[64. 小建中汤证](#)
[65. 理中汤证](#)
[66. 桂枝人参汤证](#)
[67. 四逆汤证](#)
[68. 四逆加人参汤证](#)
[69. 白通汤证](#)
[70. 桃花汤证](#)
[71. 真武汤证](#)
[72. 黄连阿胶汤证](#)
[73. 猪苓汤证](#)
[74. 猪肤汤证](#)
[75. 半夏汤证](#)
[76. 四逆散证](#)
[77. 吴茱萸汤证](#)
[78. 白头翁汤证](#)
[79. 白头翁加阿胶汤证](#)
[80. 当归四逆汤证](#)
[81. 干姜黄芩黄连人参汤证](#)
[82. 芍药甘草汤证](#)
[83. 甘草附子汤证](#)
[84. 桂枝附子去桂加白术汤证](#)
[85. 竹叶石膏汤证](#)
[86. 牡蛎泽泻散证](#)
[87. 百合地黄汤证](#)
[88. 防己黄芪汤证](#)
[89. 苓桂汤证](#)
[90. 旋覆花汤证](#)
[91. 甘姜苓术汤证](#)
[92. 酸枣仁汤证](#)
[93. 射干麻黄汤证](#)
[94. 大黄牡丹汤证](#)
[95. 泽泻汤证](#)
[96. 半夏厚朴汤证](#)
[97. 桂枝茯苓丸证](#)

[98. 当归芍药散证](#)

[99. 温经汤证](#)

[下篇 医论集](#)

[1. 张仲景当归剂的证治特点](#)

[2. 心悸的辨证与治疗](#)

[3. 人体的“津液链”](#)

[4. “战汗”的发生、治疗及护理](#)

[5. 苏子降气汤证的病理特点及其临床运用](#)

[6. 温胆汤的临床运用](#)

[7. 加减木防己汤治疗湿热痹](#)

[8. 温病证治约言](#)

[9. 阴虚性肝胃不和的证治](#)

[10. 益胃汤的临床运用](#)

[11. 三甲复脉汤的临床运用](#)

[12. “甘温除大热”及东垣方的临床运用](#)

[肝病证治概要](#)

[封面](#)

[内封](#)

[版权页](#)

[刘渡舟医书七种编写委员会](#)

[出版说明](#)

[整理说明](#)

[前言](#)

[Table of Contents](#)

[上篇 概论](#)

[一、肝在生命运动中的地位和生理特点](#)

[二、肝病的病变规律](#)

[三、肝病的诊断学特点](#)

[四、肝病的治疗原则](#)

[中篇 肝病证治规律](#)

[第一章 肝气郁结证治](#)

[第二章 肝气冲逆证治](#)

[第三章 肝火证治](#)

[第四章 肝火伤阴证治](#)

[第五章 肝风证治](#)

[第六章 湿热诸毒黄疸证治](#)

[第七章 气血瘀滞证治](#)

[第八章 寒热错杂证治](#)

[第九章 肝寒证治](#)

[第十章 肝虚证治](#)

[下篇 附篇](#)

[一、《西溪书屋夜话录》评讲](#)

[二、胆腑理论及临床](#)

[三、肝病用药指归](#)